AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3

1.556

GUÍA COMPLETA · 21 ESPECIALIDADES

Perfil de Conocimientos EUNACOM

CÓDIGO POR CÓDIGO

Cada código del Perfil V3 con su nivel exigido. dónde se enseña. qué hay que saber y sus preguntas

---

1.556 códigos · 3.689 preguntas

Academia Examen EUNACOM

AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

GUÍA GRATUITA

ESTA GUÍA ES SOLO EL COMIENZO

PREPARA EL EUNACOM CON LA ACADEMIA

La plataforma de la Academia Examen EUNACOM (AEE): el banco de preguntas reales más completo de Chile, clases en video y simulacros, todo ordenado según el Perfil V3.

+11.000
PREGUNTAS REALES EUNACOM
Todos los exámenes 2013 – 2026, con explicación

+300
VIDEOS
Masterclasses con algoritmos y casos clínicos

Reconstrucciones
DE CADA EXAMEN
Las preguntas tal como se tomaron, ordenadas por fecha

Simulacros
CRONOMETRADOS
Practica en condiciones reales de examen

21
MANUALES AEE
Un tomo por especialidad, alineado al Perfil V3

1.556
CÓDIGOS DEL PERFIL
Cada uno con su clase y sus preguntas

25%

de descuento en todos los cursos

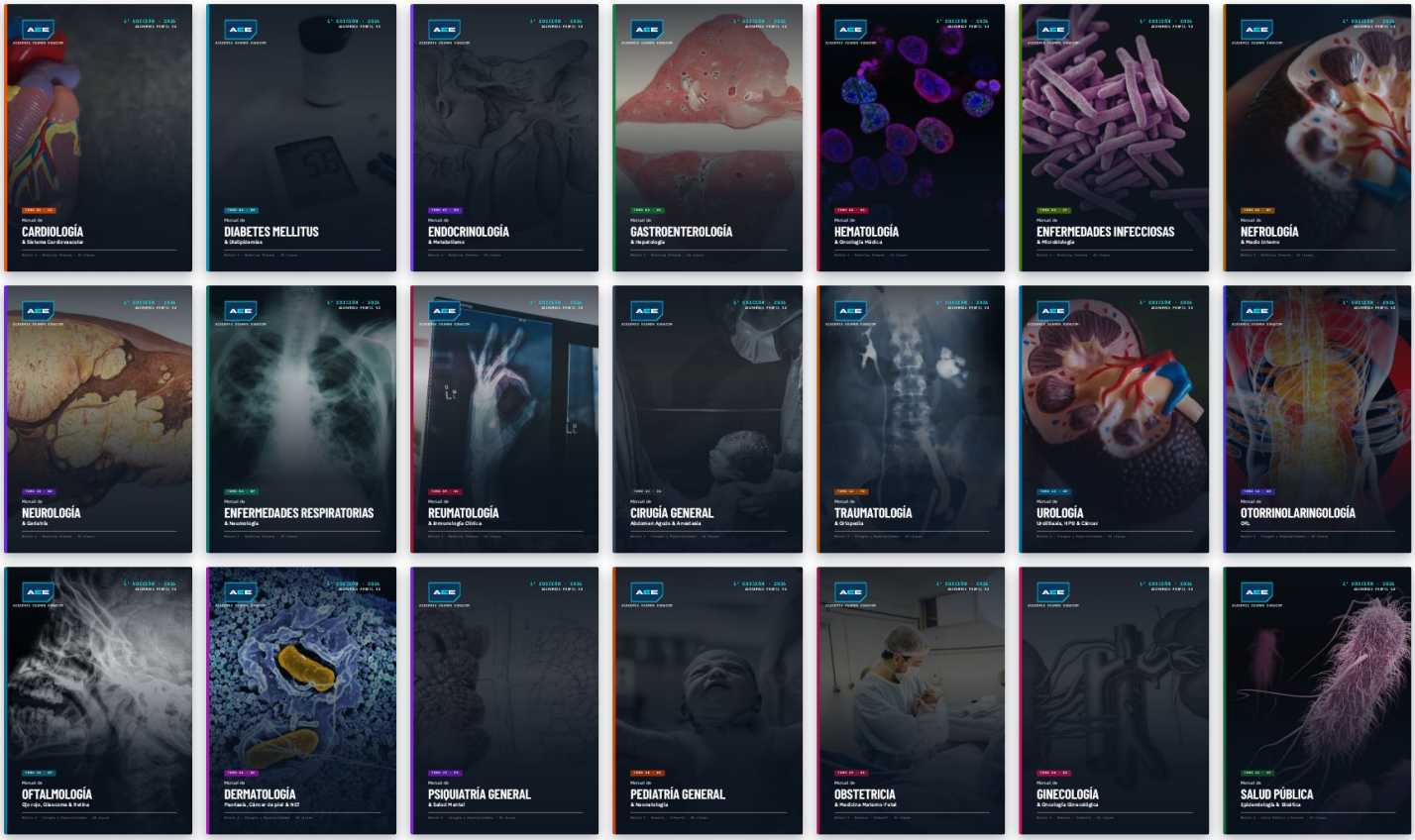
Escanea el código o entra a **eunacom-examen.cl** y usa el cupón

PERFILV3

LA COLECCIÓN AEE

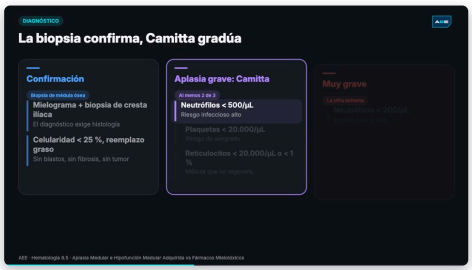
21 manuales, uno por especialidad

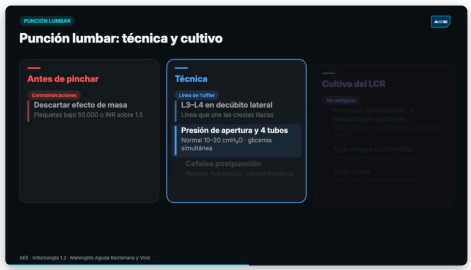
Los manuales siguen el Perfil V3 tema por tema: cada párrafo marca el código que enseña, con algoritmos, tablas, fotos clínicas y preguntas reales. Disponibles en la plataforma.



Masterclases en video

Cada tema tiene su clase: el profesor explica el porqué, el árbol de decisión se arma en pantalla y cerramos con preguntas reales del EUNACOM. Toca «Ver clase» en cualquier ficha de esta guía.





Entra a eunacom-examen.cl · cupón PERFILV3 · 25 % de descuento

CÓMO USAR ESTA GUÍA

Un código, una ficha

Cada ficha corresponde a un código del Perfil de Conocimientos EUNACOM V3 (ASOFAMECh 2026). Busca el código en el índice: el número de página y el propio código son enlaces. Dentro de la ficha, el código te devuelve al índice.

1.01.1.006 **Nombre oficial del código**

Nivel exigido · Dónde se enseña en los manuales AEE · Qué hay que saber · Preguntas reales EUNACOM con su respuesta

Niveles del Perfil

Diagnóstico (Dx)	ESPECÍFICO confirmar el diagnóstico	SOSPECHA reconocer y derivar
Tratamiento (Tx)	COMPLETO manejar de principio a fin	INICIAL estabilizar y derivar
Seguimiento (Seg)	COMPLETO controlar al paciente	DERIVAR derivar al especialista · NO REQUIERE

Tipos de pregunta

PREGUNTA REAL examen EUNACOM con fecha y número. PREGUNTA DEL LIBRO o DE PRÁCTICA : redactadas por AEE para los códigos sin pregunta oficial.

CONTENIDO

Índice general

MÓDULO 1 MEDICINA INTERNA 655 códigos

01 Cardiología 61 códigos 16
02 Diabetes y Nutrición 68 códigos 76
03 Endocrinología 42 códigos 124
04 Enfermedades Infecciosas 72 códigos 167
05 Enfermedades Respiratorias 83 códigos 219
06 Gastroenterología 64 códigos 282
07 Geriatría 38 códigos 343
08 Hemato-oncología 58 códigos 368
09 Nefrología 72 códigos 413
10 Neurología 62 códigos 462
11 Reumatología 35 códigos 511

MÓDULO 2 CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES 528 códigos

12 Cirugía General y Anestesia 155 códigos 554
13 Traumatología 45 códigos 647
14 Urología 62 códigos 685
15 Psiquiatría 60 códigos 731
16 Dermatología 60 códigos 798
17 Oftalmología 63 códigos 838
18 Otorrinolaringología 83 códigos 882

MÓDULO 3 MATERNO-INFANTIL 318 códigos

19 Pediatría 227 códigos 929
20 Obstetricia y Ginecología 91 códigos 1093

MÓDULO 4 SALUD PÚBLICA 55 códigos

21 Salud Pública 55 códigos 1193

Índice de códigos 6

ÍNDICE

Índice de códigos

Toca el código para ir a su ficha y sus preguntas.

01 Cardiología

1.01.1.001 Angina crónica estable 17
1.01.1.002 Bloqueos aurículo-ventriculares 18
1.01.1.003 Cardiopatía congénita en adulto 19
1.01.1.004 Corazón pulmonar crónico 22
1.01.1.005 Dislipidemias 23
1.01.1.006 Embolia pulmonar 24
1.01.1.007 Endocarditis infecciosa y no infecciosa 25
1.01.1.008 Enfermedad reumática activa 25
1.01.1.009 Estenosis aórtica 26
1.01.1.010 Estenosis mitral 28
1.01.1.011 Extrasistolía ventricular benigna 29
1.01.1.012 Fibrilación auricular crónica 29
1.01.1.013 Fibrilación auricular paroxística 30
1.01.1.014 Flutter auricular 32
1.01.1.015 Hipertensión arterial esencial 33
1.01.1.016 Hipertensión arterial secundaria 37
1.01.1.017 Insuficiencia aórtica 38
1.01.1.018 Insuficiencia cardíaca 39
1.01.1.019 Insuficiencia mitral 41
1.01.1.020 Miocardiopatías 42
1.01.1.021 Paciente con soplo 44
1.01.1.022 Pericarditis aguda 44
1.01.1.023 Síndrome metabólico 46
1.01.1.024 Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) 46
1.01.2.001 Angina inestable 48
1.01.2.002 Disección aórtica 49
1.01.2.003 Embolia cardiogénica 51
1.01.2.004 Infarto agudo al miocardio 52
1.01.2.005 Insuficiencia cardíaca aguda 55
1.01.2.006 Paro cardiorespiratorio 56
1.01.2.007 Shock 57
1.01.2.008 Taponamiento pericárdico 57
1.01.2.009 Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico 58
1.01.3.001 Alimentación saludable 59
1.01.3.002 Cardiopatía y embarazo 60
1.01.3.003 Manejo del paciente en tratamiento anticoagulante 60
1.01.3.004 Obesidad y sobrepeso 61
1.01.3.005 Prevención de enfermedad reumática 61
1.01.3.006 Sedentarismo vs actividad física 62
1.01.3.007 Tabaquismo: prevención, cesación y efectos nocivos para la salud 62
1.01.4.001 Coronariografía 63
1.01.4.002 Angiotac de tórax y aorta 63
1.01.4.003 Radiografía de tórax 64
1.01.4.005 Cintigrafía de perfusión miocárdica 64
1.01.4.006 Ecocardiografía 65
1.01.4.007 Electrocardiograma 66
1.01.4.008 Test de esfuerzo 67
1.01.4.009 Enzimas cardíacas (CPK, MB, LDH, troponinas) 67
1.01.4.010 Hemograma y velocidad de hemosedimentación (VHS) 68
1.01.4.011 Holter de presión arterial 68
1.01.4.012 Perfil bioquímico 69
1.01.4.013 Perfil lipídico 69
1.01.4.014 Holter de ritmo 70
1.01.5.002 Cardioversión eléctrica 70
1.01.5.003 Cateterismo venoso central 71
1.01.5.004 Desfibrilación 71
1.01.5.005 Intubación traqueal 72
1.01.5.006 Resucitación cardiorespiratoria 72
1.01.5.007 Punción pericárdica 73
1.01.5.008 Punción venosa 74
1.01.5.009 Trombolisis 74

02 Diabetes y Nutrición

1.02.1.001 Desnutrición 77
1.02.1.002 Diabetes gestacional 77
1.02.1.003 Diabetes mellitus pregestacional 79
1.02.1.004 Diabetes Mellitus tipo 1 80
1.02.1.005 Diabetes mellitus tipo 2 81
1.02.1.006 Diabetes por corticoides 86
1.02.1.007 Dislipidemias 87
1.02.1.008 Hipertensión arterial en diabetes tipo 2 88
1.02.1.009 Insuficiencia renal y diabetes 89
1.02.1.010 Nefropatía incipiente 90
1.02.1.011 Neuropatía diabética 90
1.02.1.012 Obesidad 91
1.02.1.013 Obesidad mórbida 91
1.02.1.014 Pié diabético y otras infecciones en diabetes 92
1.02.1.015 Retinopatía diabética 93
1.02.1.016 Síndrome metabólico 93
1.02.1.017 Síndromes carenciales de vitaminas y minerales 94
1.02.1.018 Trastornos de conducta alimentaria 95
1.02.1.019 Vasculopatía periférica 95
1.02.2.001 Acidosis láctica 96
1.02.2.002 Cetoacidosis 96
1.02.2.003 Coma hiperosmolar 99
1.02.2.004 Déficit agudo de tiamina 99
1.02.2.005 Hipertrigliceridemia grave 100
1.02.2.006 Hipoglicemias 101
1.02.2.007 Síndrome hiperosmolar no cetósico 102
1.02.3.001 Alimentación saludable 104
1.02.3.002 Anorexia nerviosa 104
1.02.3.003 Diabetes y riesgo cardiovascular 105
1.02.3.004 Estilos de vida saludables (hábitos y conductas) 105
1.02.3.005 Prevención de complicaciones crónicas de la diabetes 106
1.02.3.006 Prevención de Diabetes Mellitus tipo 2 106
1.02.3.007 Prevención de dislipidemias 107
1.02.3.008 Prevención de la obesidad 107
1.02.3.009 Prevención de pié diabético 108
1.02.3.010 Regímenes dietéticos fundamentales 108
1.02.3.011 Regímenes dietéticos para dislipidemias 109
1.02.3.012 Regímenes dietéticos para obesidad 109
1.02.3.013 Riesgo cardiovascular global 110
1.02.3.014 Síndrome metabólico 110
1.02.4.001 Arteriografia extremidades inferiores 110
1.02.4.002 Ecotomografia abdominal 111
1.02.4.003 Albúmina plasmática 111
1.02.4.004 Relación albuminuria / creatininuria 112
1.02.4.005 Creatininemia 112
1.02.4.006 Cuerpos cetónicos en orina (semicuantitativo) 113
1.02.4.007 Cuerpos cetónicos en sangre 113
1.02.4.008 Doppler vascular periférico 113
1.02.4.009 Electrocardiograma 114
1.02.4.010 Electromiografía 114
1.02.4.011 Estudio funcional hepático 115
1.02.4.012 Evaluación nutricional 115
1.02.4.013 Examen de orina completa 115
1.02.4.014 Examen de orina semicuantitativa 116
1.02.4.015 Glicemia capilar 116
1.02.4.016 Glicemia venosa 117
1.02.4.017 Hemoglobina glicosilada 118
1.02.4.018 Insulinemia 118
1.02.4.019 Microalbuminuria 119
1.02.4.020 Nitrogeno urinario 119
1.02.4.021 Perfil lipídico 120
1.02.4.022 Proteiuniria 24 horas 120
1.02.4.023 Test de esfuerzo 120
1.02.4.024 Test de tolerancia a la glucosa 121
1.02.4.025 Urocultivo y antibiograma 122
1.02.5.001 Curaciones básicas del pié diabético 122
1.02.5.002 Evaluacion nutricional subjetiva 122
1.02.5.003 Fondo de ojo 123

03 Endocrinología

1.03.1.001 Bocio 125
1.03.1.002 Hipotiroidismo 125
1.03.1.003 Hipertiroidismo 128
1.03.1.004 Cáncer del tiroides 130
1.03.1.005 Tiroiditis 130
1.03.1.006 Síndrome de Cushing 131
1.03.1.007 Insuficiencia suprarrenal crónica 133
1.03.1.008 Hirsutismo 134
1.03.1.009 Hipertensión arterial de origen endocrino 135
1.03.1.010 Amenorrea 137
1.03.1.011 Síndrome climatérico 138
1.03.1.012 Hipogonadismo masculino 139
1.03.1.013 Tumores hipofisiarios 140
1.03.1.014 Hipopituitarismo 142
1.03.1.015 Diabetes insípida 143

1.03.1.016 Hiperprolactinemia 144
1.03.1.017 Síndrome de secreción inapropiada de ADH 145
1.03.1.018 Osteoporosis 146
1.03.1.019 Osteoporosis secundaria 147
1.03.1.020 Hipercalcemias e hipocalcemias 147
1.03.1.021 Nódulo tiroídeo 150
1.03.1.022 Incidentaloma suprarrenal 153
1.03.1.023 Ginecomastia 153
1.03.2.001 Tormenta tiroidea 154
1.03.2.002 Mixedema 155
1.03.2.003 Insuficiencia suprarrenal aguda 156
1.03.2.004 Hipercalcemia aguda 157
1.03.2.005 Tetania 157
1.03.3.001 Pubertad normal 158
1.03.3.002 Prevención de osteoporosis 159
1.03.3.003 Complicaciones del tratamiento esteroidal 159
1.03.4.001 Ecografía tiroídea 160
1.03.4.002 Densitometría ósea 160
1.03.4.003 TSH, T4, T3 161
1.03.4.004 T4 libre 162
1.03.4.005 Anticuerpos antitiroideos (antitiroglobulina y antiiroperoxidasa) 162
1.03.4.006 Cortisol plasmático 163
1.03.4.007 Cortisol libre 24 horas 163
1.03.4.008 FSH, estradiol y prolactina 164
1.03.4.009 LH, testosterona 164
1.03.4.010 PTH, calcemia 165
1.03.4.011 Calciuria 166

04 Enfermedades Infecciosas

1.04.1.001 Adenitis, adenoflegmón 168
1.04.1.003 Ántrax 168
1.04.1.004 Brucelosis 169
1.04.1.005 Candidiasis oral y esofágica 170
1.04.1.006 Celulitis bacteriana 170
1.04.1.007 Cólera 171
1.04.1.008 Dengue 171
1.04.1.009 Diarrea asociada a antibióticos 172
1.04.1.010 Enfermedades de transmisión sexual 173
1.04.1.011 Enfermedades eruptivas no complicadas (varicela, herpes zoster...) 176
1.04.1.012 Fiebre tifoídea y paratifoídea 177
1.04.1.013 Hidatidosis 177
1.04.1.014 Infección por virus de inmunodeficiencia humana (SIDA) 178
1.04.1.015 Infecciones asociadas a catéteres vasculares 181
1.04.1.016 Influenza 181
1.04.1.017 Leptospirosis 182
1.04.1.018 Malaria 182
1.04.1.019 Micosis invasora (aspergillosis, candidiasis, mucormicosis) 183
1.04.1.020 Neutropenia febril 184
1.04.1.021 Osteomielitis 185
1.04.1.022 Parasitosis intestinales 185
1.04.1.023 Sífilis secundaria, terciaria y congénita 186
1.04.1.024 Síndrome febril prolongado 187
1.04.1.025 Síndrome mononucleósico 188
1.04.1.026 Toxicoinfección alimentaria 189
1.04.1.027 Triquinosis 190
1.04.1.028 Tuberculosis extrapulmonar 191
1.04.1.029 Enfermedad leve moderada por SARS Cov 2 COVID 19 193
1.04.2.001 Absceso cerebral 193
1.04.2.002 Encefalitis aguda 193
1.04.2.003 Endocarditis bateriana 194
1.04.2.004 Flegmón submaxilar, submandibular y del piso de la boca 195
1.04.2.005 Infección invasiva de partes blandas: celulitis, fasceitis, miositis necrotiza... 195
1.04.2.006 Meningitis aguda 196
1.04.2.007 Sepsis y shock séptico 197
1.04.2.008 Síndrome pulmonar por Hanta Virus 198
1.04.2.009 Tétanos 199
1.04.2.010 Varicela complicada: neumonitis, cerebelitis, encefalitis 199
1.04.2.011 Enfermedad grave por SARS Cov 2 COVID 19 200
1.04.3.001 Manejo y prevención de infecciones en personal sanitario 200
1.04.3.002 Mordeduras de animales 201
1.04.3.003 Prevención de enfermedades de transmisión sexual 201
1.04.3.004 Prevención de enfermedades entéricas 202
1.04.3.005 Prevención de infecciones hospitalarias 202
1.04.3.006 Prevención de infecciones oportunistas en VIH (+) 203
1.04.3.007 Profilaxis de endocarditis infecciosa 203
1.04.3.008 Profilaxis de tétanos 204
1.04.3.009 Profilaxis de tuberculosis 204
1.04.3.010 Profilaxis en contactos de infecciones meningocócicas 205
1.04.3.011 Uso y abuso de antibióticos 206
1.04.3.012 Vacunas especiales (neumococo, influenza, hepatitis A y B, varicela, rabia... 207
1.04.3.013 Vacunas incluidas en el PNI (Plan Nacional de Inmunizaciones) 207
1.04.4.001 Antigenemia 208
1.04.4.002 Cultivo de heridas o abscesos 208
1.04.4.003 Cultivos de hongos 209
1.04.4.004 Detección de antígeno de Cryptococcus en LCR y test de tinta china 209
1.04.4.005 Detección de agentes virales por inmunofluorescencia 210
1.04.4.006 Estudio citoquímico de LCR 210
1.04.4.007 Cultivo de expectoración 211
1.04.4.008 Gram 211
1.04.4.009 Hemocultivo 212
1.04.4.010 Hemograma y velocidad de hemosedimentación (VHS) 212
1.04.4.011 Parasitológico de deposiciones 213
1.04.4.012 Proteína C reactiva 213
1.04.4.014 Pruebas rápidas para diagnóstico de estreptococo grupo A 214
1.04.4.015 Reacción de polimerasa en cadena 214
1.04.4.016 Serología de enfermedades infecciosas 215
1.04.4.017 Urocultivo y antibiograma 216
1.04.5.001 Drenaje de abscesos superficiales 216
1.04.5.002 Punción lumbar 217
1.04.5.003 Sembrar muestras para cultivo 217
1.04.5.004 Tinción de Gram 218

05 Enfermedades Respiratorias

1.05.1.001 Absceso pulmonar 220
1.05.1.002 Asma bronquial grave 220
1.05.1.003 Asma bronquial leve y moderada 221
1.05.1.004 Bronquiectasias 224
1.05.1.005 Bronquitis aguda 226
1.05.1.006 Bronquitis crónica 226
1.05.1.007 Cáncer bronquial primario 227
1.05.1.008 Corazón pulmonar crónico 229
1.05.1.009 Daño pulmonar secundario a drogas 229
1.05.1.010 Derrame pleural neoplásico 230
1.05.1.011 Derrame pleural paraneumónico complicado 232
1.05.1.012 Derrame pleural paraneumónico simple 232
1.05.1.013 Derrame pleural por tuberculosis 233
1.05.1.014 Edema pulmonar no cardiogénico 233
1.05.1.015 Embolia pulmonar 234
1.05.1.016 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada 237
1.05.1.017 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve y moderada 237
1.05.1.018 Enfermedades del intersticio pulmonar 238
1.05.1.019 Hemoptisis leve y mediana 239
1.05.1.020 Hidatidosis pulmonar 240
1.05.1.021 Hipertensión pulmonar 240
1.05.1.022 Infecciones de las vías aéreas superiores 241
1.05.1.023 Insuficiencia respiratoria crónica 241
1.05.1.024 Intoxicación leve por CO y otros gases 242
1.05.1.025 Metástasis pulmonares 242
1.05.1.026 Neumoconiosis 243
1.05.1.027 Neumonías adquiridas en la comunidad (tipo 4 de la Sociedad Chilena de ... 243
1.05.1.028 Neumonías adquiridas en la comunidad (tipos 1, 2 y 3 de la Sociedad Chil... 246
1.05.1.029 Neumonías en inmunosuprimidos 246
1.05.1.030 Neumonías nosocomiales 247
1.05.1.031 Neumotórax moderado y grande 248
1.05.1.032 Neumotórax pequeño 248
1.05.1.033 Síndrome de apnea del sueño 249
1.05.1.034 Síndromes mediastínicos 250
1.05.1.035 Tos crónica 250
1.05.1.036 Tuberculosis pulmonar 251
1.05.1.037 Tuberculosis pulmonar (fracaso de tratamiento) 252
1.05.1.038 Nódulos pulmonares 252
1.05.2.001 Asfixia por inmersión 253
1.05.2.002 Aspiración de cuerpo extraño con asfixia 253
1.05.2.003 Aspiración de cuerpo extraño sin asfixia 254
1.05.2.004 Crisis de asma bronquial 254
1.05.2.005 Embolia pulmonar masiva 255
1.05.2.006 Enfermedad bronquial obstructiva crónica descompensada 256
1.05.2.007 Hemoptisis moderada,severa y masiva 256
1.05.2.008 Insuficiencia respiratoria aguda o crónica reagudizada que requiere ventil... 257
1.05.2.009 Insuficiencia respiratoria aguda o crónica reagudizada, que no requiere v... 258
1.05.2.010 Intoxicación por monóxido de carbono 258
1.05.2.011 Neumotórax hipertensivo 260
1.05.2.012 Paro cardiorespiratorio 261
1.05.2.013 Traumatismo torácico grave 261
1.05.2.014 Traumatismo torácico simple 262
1.05.3.001 Contaminación ambiental 262
1.05.3.002 Prevención de daño pulmonar por inhalantes domésticos y laborales 263
1.05.3.003 Programa Nacional de Control de TBC 263
1.05.3.004 Tabaquismo: prevención, cesación y efectos nocivos para la salud 264
1.05.3.005 Vacunación (tuberculosis, influenza, Coronavirus SARS-CoV-2 y neumoco... 264
1.05.4.001 Radiografía de tórax 265
1.05.4.002 TAC de tórax 265
1.05.4.003 Ecografía pleural 266
1.05.4.004 Baciloscopia y cultivo de Koch de expectoración 266
1.05.4.005 Espirometría 267
1.05.4.006 Examen microbiológico de expectoración 268
1.05.4.007 Citoquímico de líquido pleural 269
1.05.4.008 Examen microbiológico de líquido pleural 269

1.05.4.009 Flujo espiratorio máximo (PEF: Peak Expiratory Flow) 270
1.05.4.010 Gases en sangre arterial 270
1.05.4.011 PPD 271
1.05.4.012 Prueba de provocación bronquial con fármacos 272
1.05.4.013 Pruebas cutáneas de alergia 273
1.05.4.014 Saturometría arterial 274
1.05.5.001 Aspiración traqueal 274
1.05.5.002 Biopsia pleural 275
1.05.5.003 Cricoidostomía 275
1.05.5.004 Drenaje pleural 276
1.05.5.005 Fibrobroncoscopia 276
1.05.5.006 Inhalación de aerosoles presurizados 277
1.05.5.007 Intubación traqueal 277
1.05.5.008 Nebulizaciones 278
1.05.5.009 Punción pleural 278
1.05.5.010 Resucitación cardiorespiratoria 279
1.05.5.011 Ventilación mecánica invasiva 279
1.05.5.012 Ventilación mecánica no invasiva 280

06 Gastroenterología

1.06.1.001 Ascitis 283
1.06.1.002 Cáncer de páncreas 283
1.06.1.003 Cáncer de vesícula y vías biliares 285
1.06.1.004 Cáncer gástrico 285
1.06.1.005 Cirrosis hepática 286
1.06.1.006 Colelitiasis 287
1.06.1.007 Colestasia 288
1.06.1.008 Trastornos digestivos funcionales 289
1.06.1.009 Constipación 290
1.06.1.010 Diarrea asociada a antibióticos 290
1.06.1.011 Diarrea crónica 291
1.06.1.012 Diarrea en inmunosuprimidos 291
1.06.1.013 Disfagia 292
1.06.1.014 Dispepsia 293
1.06.1.015 Enfermedad celiaca 294
1.06.1.016 Enfermedad diverticular complicada 296
1.06.1.017 Enfermedad diverticular no complicada 298
1.06.1.018 Enfermedad inflamatoria intestinal 299
1.06.1.019 Hepatitis aguda A no complicada 304
1.06.1.020 Hepatitis agudas B, C, por otros virus, por drogas y tóxicas 305
1.06.1.021 Hepatitis crónica 305
1.06.1.022 Insuficiencia hepática crónica 306
1.06.1.023 Intolerancia a la lactosa 306
1.06.1.024 Masa hepática 307
1.06.1.025 Pancreatitis crónica 309
1.06.1.026 Parasitosis intestinales 310
1.06.1.027 Reflujo gastroesofágico 310
1.06.1.028 Síndrome de malabsorción 312
1.06.1.029 Tumores de colon 313
1.06.1.030 Úlcera péptica 315
1.06.2.001 Abdomen agudo 317
1.06.2.002 Afagia aguda 318
1.06.2.003 Colangitis 318
1.06.2.004 Colecistitis aguda 320
1.06.2.005 Diarrea aguda 321
1.06.2.006 Encefalopatía hepática 321
1.06.2.007 Hemorragia digestiva alta y baja 322
1.06.2.008 Hepatitis aguda A complicada 325
1.06.2.009 Insuficiencia hepática aguda 325
1.06.2.010 Pancreatitis aguda 326
1.06.2.011 Peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico 327
1.06.2.012 Síndrome hepatorrenal 329
1.06.3.001 Vacunación de hepatitis A y B 330
1.06.3.002 Manejo dietético en enfermos digestivos 330
1.06.3.003 Epidemiología de los cánceres digestivos 331
1.06.3.004 Métodos de tamizaje para cáncer de colon y hepatocarcinoma 331
1.06.3.005 Antiinflamatorios no esteroidales y tracto gastrontestinal 332
1.06.3.006 Esteatopatía no alcohólica 332
1.06.4.001 Radiografía simple de abdomen 333
1.06.4.002 Tránsito esófago-estómago-duodeno 333
1.06.4.003 Enema barritada 334
1.06.4.004 Colangiografía endoscópica 334
1.06.4.005 TAC abdominal 335
1.06.4.006 Ecotomografía abdominal 335
1.06.4.007 Endoscopía digestiva alta y baja 336
1.06.4.008 Biopsia hepática 337
1.06.4.009 Sangre oculta en deposiciones 337
1.06.4.010 Estudio de perfil hepático 338
1.06.4.011 Estudio de función hepática 338
1.06.4.012 Estudio de marcadores virales para hepatitis A, B y C 339
1.06.4.013 Laboratorio inicial de síndrome de malabsorción 339
1.06.4.014 Determinación toxina C difficile en deposiciones 340
1.06.4.015 Colangiografía por resonancia magnética 340
1.06.5.001 Paracentesis 341

07 Geriatría

1.07.1.001 Caídas 344
1.07.1.002 Constipación y fecalomas 344
1.07.1.003 Demencia 345
1.07.1.004 Depresión 346
1.07.1.005 Diabetes mellitus tipo 2 346
1.07.1.006 Enfermedad cerebro-vascular 347
1.07.1.007 Escaras o úlceras por presión 347
1.07.1.008 Fragilidad 348
1.07.1.009 Hipertensión arterial 349
1.07.1.010 Hipotensión postural 349
1.07.1.011 Hipotermia 350
1.07.1.012 Incontinencia urinaria 350
1.07.1.013 Inmovilidad 351
1.07.1.014 Malnutrición 351
1.07.1.015 Osteoporosis 352
1.07.1.016 Temblor 352
1.07.1.017 Trastornos de la marcha 353
1.07.2.001 Abdomen agudo en adulto mayor 353
1.07.2.002 Evento coronario en adulto mayor 354
1.07.2.003 Fractura de cadera 354
1.07.2.004 Agitación y agresividad 355
1.07.2.005 Síndrome confusional agudo / delirium 356
1.07.3.001 Alteración de la termoregulación 359
1.07.3.002 Complicaciones en el adulto mayor hospitalizado 359
1.07.3.003 Manejo, cuidado y acompañamiento de final de vida 360
1.07.3.004 Ejercicio en personas mayores 360
1.07.3.005 Envejecimiento saludable y promoción del autocuidado 360
1.07.3.006 Inmunizaciones en personas mayores 361
1.07.3.007 Manejo de fármacos en la persona mayor 361
1.07.3.008 Nutrición en las personas mayores 363
1.07.3.009 Prevención del deterioro funcional 363
1.07.3.010 Sexualidad en personas mayores 364
1.07.3.011 Adecuación del entorno para personas mayores 364
1.07.3.012 Derecho GES a ayudas técnicas para personas de 65 años o más, como ór... 365
1.07.5.001 Valoración afectiva 365
1.07.5.002 Valoración cognitiva 366
1.07.5.003 Valoración de la marcha 366
1.07.5.004 Valoración funcional 367

08 Hemato-oncología

1.08.1.001 Anemia de las enfermedades crónicas 369
1.08.1.002 Anemia ferropénica 369
1.08.1.003 Anemia hemolítica 370
1.08.1.004 Anemia megaloblástica 372
1.08.1.005 Coagulopatías adquiridas 375
1.08.1.006 Coagulopatías congénitas (hemofilias, von Willebrand) 375
1.08.1.007 Disproteinemias (gammapatías M) 376
1.08.1.008 Hipofunción medular 377
1.08.1.009 Leucemias agudas 378
1.08.1.010 Leucemias crónicas 379
1.08.1.011 Linfomas 380
1.08.1.012 Púrpuras trombopénicos 382
1.08.1.013 Púrpuras vasculares 383
1.08.1.014 Reacción leucemoide 384
1.08.1.015 Síndrome leucoeritroblástico 384
1.08.1.016 Síndrome paraneoplásico 385
1.08.1.017 Síndromes mielodisplásicos 385
1.08.1.018 Síndromes mieloproliferativos crónicos 386
1.08.1.019 Trombofilias 386
1.08.2.001 Coagulación intravascular diseminada 387
1.08.2.002 Coagulopatía adquirida 388
1.08.2.003 Coagulopatía congénita sangrante 389
1.08.2.004 Hipercalcemia 389
1.08.2.005 Lisis tumoral aguda 390
1.08.2.006 Neutropenia febril 391
1.08.2.007 Síndrome de compresión medular 392
1.08.2.008 Síndrome vena cava superior 393
1.08.2.009 Trombopenia severa 394
1.08.3.001 Alcoholismo y asociación con carencias nutricionales 394
1.08.3.002 Conceptos generales de etapificación, radioterapia y quimioterapia 395
1.08.3.003 Efectos mielotóxicos de drogas y medicamentos 396
1.08.3.004 Actividad física en pacientes con riesgo de trombosis 396
1.08.3.005 Indicaciones de uso de componentes sanguíneos 397
1.08.3.006 Interacción de drogas y anticoagulantes orales 397
1.08.3.007 Manejo del dolor crónico y paliativo 398
1.08.3.008 Manejo del paciente terminal oncológico 398
1.08.3.009 Prevención de anemias por carencias nutricionales 399
1.08.3.010 Prevención de infecciones con énfasis en inmunosuprimidos 399
1.08.3.011 Transfusión y sus complicaciones 400
1.08.3.012 Tratamiento anticoagulante 400
1.08.4.001 Radiografía de tórax 401
1.08.4.002 Cintigrafía ósea y cintigrafía con galio 402

1.08.4.003 Biopsia de médula ósea 402
1.08.4.004 Electroforesis de proteínas 402
1.08.4.005 Estudio de coagulopatías 403
1.08.4.006 Estudio de trombofilia 404
1.08.4.007 Estudio de trombopatías 404
1.08.4.008 Hemograma 405
1.08.4.009 Mielograma 406
1.08.4.010 Pruebas de hemólisis 407
1.08.5.001 Biopsia de médula ósea 408
1.08.5.002 Biopsia ganglionar 408
1.08.5.003 Biopsia hepática 409
1.08.5.004 Cateterismo venoso central 409
1.08.5.005 Mielograma 410
1.08.5.006 Punción lumbar 410
1.08.5.007 Punción venosa 411
1.08.5.008 Quimioterapia intratecal 411

09 Nefrología

1.09.1.001 Acidosis e hiperkalemia en Insuficiencia renal crónica 414
1.09.1.002 Acidosis metabólica 414
1.09.1.003 Alcalosis metabólica 415
1.09.1.004 Anemia en nefrópata 415
1.09.1.005 Bacteriuria asintomática 416
1.09.1.006 Glomerulopatía lúpica 416
1.09.1.007 Hipernatremia, poliuria 418
1.09.1.008 Hipertensión arterial esencial 419
1.09.1.009 Hipertensión arterial secundaria 419
1.09.1.010 Hiponatremia crónica asintomática 420
1.09.1.011 Infección urinaria baja (cistitis) 421
1.09.1.012 Insuficiencia renal crónica 421
1.09.1.013 Nefritis intersticial no infecciosa (aguda o crónica) 422
1.09.1.014 Nefropatía diabética 423
1.09.1.015 Osteodistrofia en insuficiencia renal crónica 424
1.09.1.016 Pielonefritis aguda no complicada 425
1.09.1.017 Progresión de la IRC 425
1.09.1.018 Proteinuria 425
1.09.1.019 Riñón poliquístico 426
1.09.1.020 Edema generalizado (anasarca) 426
1.09.1.021 Síndrome nefrítico 427
1.09.1.022 Síndrome nefrótico 429
1.09.1.023 Síndrome urémico 431
1.09.1.024 Urolitiasis 432
1.09.1.025 Uropatía obstructiva 432
1.09.2.001 Cólico nefrítico, urolitiasis y complicaciones: obstrucción, sepsis, insuficie... 433
1.09.2.002 Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas 433
1.09.2.003 Edema generalizado grave (anasarca) 434
1.09.2.004 Enfermedad tubular aguda 434
1.09.2.005 Hiperkalemia grave 435
1.09.2.006 Hipokalemia 436
1.09.2.007 Hiponatremia aguda grave 437
1.09.2.008 Hipovolemia 438
1.09.2.009 Insuficiencia renal aguda obstructiva 439
1.09.2.010 Insuficiencia renal aguda prerrenal 440
1.09.2.011 Pielonefritis aguda complicada 440
1.09.2.012 Pre eclampsia 441
1.09.2.013 Vasculitis o glomerulonefritis rápidamente progresiva 442
1.09.3.001 Ajuste de fármacos según función renal 443
1.09.3.002 Control de factores de riesgo de enfermedad vascular 444
1.09.3.003 Desnutrición en insuficiencia renal crónica 444
1.09.3.004 Diálisis y complicaciones 445
1.09.3.005 Función renal en el embarazo 445
1.09.3.006 Higiene para prevención de infección urinaria 446
1.09.3.007 Nefrotoxicidad de medicamentos y renoprotección 446
1.09.3.008 Prevención de progresión de insuficiencia renal crónica 447
1.09.3.009 Terapia diurética 447
1.09.3.010 Tratamiento no medicamentoso de la hipertensión arterial 448
1.09.3.011 Trasplante renal, indicaciones y complicaciones 448
1.09.4.001 Angiografia renal 449
1.09.4.003 Pielo TAC 449
1.09.4.004 Radiografía renal y vesical simple 450
1.09.4.005 Ecografía renal (tamaño, asimetrías, hidronefrosis) 450
1.09.4.006 Ecografía vésico-prostática básica 451
1.09.4.007 Cintigrama renal 451
1.09.4.008 Anion gap 452
1.09.4.009 Clearence de creatinina 452
1.09.4.010 Electrolitos plasmáticos 453
1.09.4.011 Estudio metabólico de urolitiasis 453
1.09.4.012 Examen de orina y sedimento urinario 454
1.09.4.013 Holter de presión arterial: conocimientos básicos 455
1.09.4.014 Nitrogeno ureico (relación bun/creatinina 455
1.09.4.015 Proteinuria 456
1.09.4.016 Sodio urinario 456
1.09.4.017 Urocultivo y antibiograma 457
1.09.5.001 Cistoscopia 457
1.09.5.002 Cistostomía de urgencia 458
1.09.5.003 Instalación pigtail 458
1.09.5.004 Instalación y cuidado de sonda Foley 459
1.09.5.005 Nefrostomia percutánea 459
1.09.5.006 Tacto ginecológico para masas u alteraciones obstructivas 460
1.09.5.007 Tacto rectal para reconocimiento básico de crecimiento prostático 460

10 Neurología

1.10.1.001 Cefalea tensional 463
1.10.1.002 Compromiso de conciencia 463
1.10.1.003 Cuadros de deterioro orgánico cerebral potencialmente reversibles (hipot... 464
1.10.1.004 Cuadros deficitarios de funciones cerebrales superiores (afasia, apraxia, ... 464
1.10.1.005 Demencia (Enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, VIH, ... 464
1.10.1.006 Enfermedad de Parkinson y parkinsonismos 466
1.10.1.007 Epilepsia 467
1.10.1.008 Esclerosis múltiple 469
1.10.1.009 Herpes zoster 470
1.10.1.010 Lumbago mecánico 470
1.10.1.011 Lumbociáticas y cervicobraquialgias. 471
1.10.1.012 Migraña 471
1.10.1.013 Neuralgia esencial del trigémino 472
1.10.1.014 Neuropatías por atrapamiento 473
1.10.1.015 Parálisis (tetraparesia, hemiparesia, etc) 474
1.10.1.016 Parálisis facial periférica 475
1.10.1.017 Polineuropatías, radiculopatías, mononeuropatías, etc... 476
1.10.1.018 Síndrome atáxico 477
1.10.1.019 Síndrome de hipertensión endocraneana 478
1.10.1.020 Síndrome miasténico 479
1.10.1.021 Síndrome miopático (distrofias musculares, polimiositis) 479
1.10.1.022 Síndromes convulsivos sintomáticos (traumático, tumores SNC, metabóli... 480
1.10.1.023 Síndromes sensitivos (polineuropatía, hemihipoestesia, dolor talámico, etc) 481
1.10.1.024 Síndromes vertiginosos centrales 481
1.10.1.025 Síndromes vertiginosos periféricos 482
1.10.1.026 Temblor esencial 482
1.10.1.027 Trastornos del sueño 483
1.10.1.028 Tumores de región sellar 484
1.10.1.029 Tumores primarios y metastásicos SNC 485
1.10.2.001 Cefalea aguda en urgencia 485
1.10.2.002 Complicaciones neurológicas de abuso de sustancias 486
1.10.2.003 Crisis convulsiva 486
1.10.2.004 Estado confusional agudo (alcohólico, tóxico metabólico) 487
1.10.2.005 Distonía aguda por fármacos (ejemplo antieméticos) 488
1.10.2.006 Encefalopatías tóxico metabólicas (urémica, hepática, etc) 488
1.10.2.007 Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, A... 489
1.10.2.008 Hemorragia subaracnoídea 492
1.10.2.009 Hipertensión endocraneana 493
1.10.2.010 Movimientos anormales inducidos por fármacos 493
1.10.2.011 Paraplejia aguda 494
1.10.2.012 Síndrome cuadraplégico agudo 494
1.10.2.013 Síndrome cuadriparético fláccido (poliradiculoneurítis aguda, Guillain-Bar... 495
1.10.2.014 Síndrome encefalítico (Herpes Simplex) 496
1.10.2.015 Síndromes convulsivos sintomáticos (traumático, por tumores del sistem... 497
1.10.2.016 Síndromes meníngeos con meningitis purulenta o bacteriana 498
1.10.2.017 Status convulsivo 498
1.10.2.018 Status migrañoso 499
1.10.2.019 Traumatismo encéfalo craneano leve 499
1.10.2.020 Traumatismo encefalocraneano grave 500
1.10.2.021 Traumatismo raquimedular 501
1.10.3.001 Manifestaciones neurológicas de abuso de sustancias y alcohol 502
1.10.3.002 Prevención de factores de riesgo cerebrovascular 503
1.10.4.001 TAC de encefalo y columna 503
1.10.4.002 Resonancia magnética de encéfalo y columna 504
1.10.4.003 Angiografía 505
1.10.4.004 Campo visual 505
1.10.4.005 Electroencefalograma 506
1.10.4.006 Electromiografia 507
1.10.4.007 Examen de líquido cefaloraquídeo (citoquímico, bacteriológico) 508
1.10.5.001 Papiloscopia (fondo de ojo) 509
1.10.5.002 Punción lumbar 509
1.10.5.003 Aplicación de tests neurocognitivos de screening (MoCA, Mini-Cog, Mini-... 509

11 Reumatología

1.11.1.001 Artritis psoriática 512
1.11.1.002 Artritis reactivas 513
1.11.1.003 Artritis reumatoídea 514
1.11.1.004 Artrosis 518
1.11.1.005 Cervicalgia 519
1.11.1.006 Columna dolorosa 520
1.11.1.007 Condrocalcinosis 520
1.11.1.008 Epicondilalgia, epitroclealgias 521
1.11.1.009 Esclerosis sistémica progresiva 522
1.11.1.010 Fibromialgia 524
1.11.1.011 Hombro doloroso 525

1.11.1.012 Lumbago infeccioso y tumoral 526
1.11.1.013 Lumbago mecánico 526
1.11.1.014 Lupus eritematoso sistémico 527
1.11.1.015 Monoartritis 529
1.11.1.016 Oligoartritis 530
1.11.1.017 Osteoporosis 530
1.11.1.018 Pelviespondilopatías seronegativas 532
1.11.1.019 Poliartritis 535
1.11.1.020 Polimiositis, dermatomiositis 536
1.11.1.021 Síndrome antifosfolípidos 538
1.11.1.022 Síndrome de Sjögren 540
1.11.1.023 Síndrome de túnel carpiano 541
1.11.1.024 Tendonitis y bursitis 541
1.11.1.025 Vasculitis sistémicas 542
1.11.2.001 Artritis séptica 545
1.11.2.002 Gota aguda 546
1.11.3.001 Condiciones de trabajo 548
1.11.3.002 Prevención de complicaciones de la terapia esteroidal 549
1.11.3.003 Riesgos deportivos 549
1.11.4.001 Densitometría ósea 550
1.11.4.002 Estudio de líquido sinovial 550
1.11.4.003 Exámenes inmunológicos del diagnóstico diferencial de mesenquimopatí... 551
1.11.4.004 Radiografía de columna y articulaciones 552
1.11.5.001 Punción articular de rodilla 553

12 Cirugía General y Anestesia

4.01.1.001 Patología glándulas salivales 555
4.01.1.002 Divertículos esofágicos 555
4.01.1.003 Divertículo de Meckel 555
4.01.1.004 Acalasia 556
4.01.1.005 Cáncer del esofágo 556
4.01.1.006 Hernia hiatal 557
4.01.1.007 Tumores gástricos benignos 557
4.01.1.008 Cáncer gástrico 558
4.01.1.009 Tumores del intestino delgado 558
4.01.1.011 Fístulas del intestino delgado 559
4.01.1.012 Megacolon 559
4.01.1.013 Enfermedad diverticular no complicada 560
4.01.1.014 Pólipos de colon y recto 560
4.01.1.015 Cáncer colorectal 561
4.01.1.016 Hemorroides - fisura anal 561
4.01.1.017 Abscesos y fístulas ano rectales 562
4.01.1.018 Enfermedades del seno pilonidal 563
4.01.1.019 Cáncer anal 564
4.01.1.020 Fisura anorectal 564
4.01.1.021 Hernias, eventraciones y evisceraciones 565
4.01.1.022 Hidatidosis hepática 566
4.01.1.023 Quistes y abscesos hepáticos 567
4.01.1.024 Tumores hepáticos 567
4.01.1.025 Colecistitis crónica 568
4.01.1.026 Ictericia obstructiva 568
4.01.1.027 Litiasis biliar 569
4.01.1.028 Cáncer de vesícula y vías biliares 569
4.01.1.029 Pancreatitis crónica 570
4.01.1.030 Cáncer de páncreas y otros tumores preampulares 570
4.01.1.031 Cáncer de páncreas 571
4.01.1.032 Masa cervical y tumores del cuello 571
4.01.1.033 Cáncer del tiroides 572
4.01.1.034 Patología benigna del tiroides 573
4.01.1.035 Cáncer de mama 573
4.01.1.036 Patología mamaria benigna 574
4.01.1.037 Hidatidosis pulmonar 576
4.01.1.038 Nódulo pulmonar solitario 576
4.01.1.039 Cáncer pulmonar 577
4.01.1.040 Hernias diafragmáticas traumáticas y congénitas 577
4.01.1.041 Síndromes mediastínicos 578
4.01.1.042 Mesotelioma pleural 578
4.01.1.043 Síndrome de ocupación pleural 579
4.01.1.044 Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea 579
4.01.1.045 Enfermedad renovascular 580
4.01.1.046 Insuficiencia cerebro vascular 580
4.01.1.047 Insuficiencia arterial crónica 581
4.01.1.048 Várices. Insuficiencia venosa crónica 581
4.01.1.049 Trombosis venosa profunda y tromboflebitis 582
4.01.1.050 Ulceras de las piernas (venosas, varicosas, hipert. y específicas) 583
4.01.1.051 Pie diabético 583
4.01.1.052 Escaras 584
4.01.1.053 Tumores benignos de partes blandas 584
4.01.1.054 Tumores malignos de partes blandas 585
4.01.1.055 Abscesos, forúnculos, panadizos, flegmones 585
4.01.1.056 Secuelas de quemaduras 586
4.01.1.057 Cicatrices viciosas 587
4.01.1.058 Condilomas 587
4.01.1.059 Onicocriptosis 588
4.01.1.060 Obesidad mórbida 588
4.01.2.001 Esofagitis cáustica 589
4.01.2.002 Abdomen agudo 589
4.01.2.003 Peritonitis 590
4.01.2.004 Hemorragia digestiva alta 591
4.01.2.005 Obstrucción Intestinal 591
4.01.2.006 Apendicitis aguda 594
4.01.2.007 Isquemia mesentérica aguda 595
4.01.2.008 Enfermedad diverticular complicada 597
4.01.2.009 Prolapso rectal 597
4.01.2.010 Trauma abdominal abierto y cerrado 598
4.01.2.011 Colecistitis aguda 599
4.01.2.012 Colangitis 600
4.01.2.013 Pancreatitis aguda 600
4.01.2.014 Heridas de cara 601
4.01.2.015 Trauma maxilofacial 601
4.01.2.016 Traumatismo torácico grave 602
4.01.2.017 Supuración pulmonar 604
4.01.2.018 Hemoptisis masiva 605
4.01.2.019 Perforación esofágica - Mediastinitis 605
4.01.2.020 Traumatismo raquimedular 606
4.01.2.021 Insufic. arterial aguda: embolia, trombosis, traumatismos 606
4.01.2.022 Aneurisma de aorta abdominal 607
4.01.2.023 Traumatismos vasculares 608
4.01.2.024 Hemorragia aguda post operatoria. 608
4.01.2.025 Heridas y contusiones menores 609
4.01.2.026 Quemaduras 609
4.01.2.027 Trauma 610
4.01.2.028 Intoxicación por anestésicos locales 611
4.01.2.029 Septicemia 611
4.01.2.030 Paro cardiorespiratorio 612
4.01.2.031 Shock 612
4.01.3.001 Alimentación en enfermedades digestivas 613
4.01.3.002 Antimicrobianos. Conceptos profilaxis y esquemas terapéuticos 613
4.01.3.003 Asepsia y antisepsia 614
4.01.3.004 Colostomías 614
4.01.3.005 Complicaciones postoperatorias frecuentes 615
4.01.3.006 Concepto de paciente quirúrgico ambulatorio 617
4.01.3.007 Conceptos básicos de anestesia general, local y regional 617
4.01.3.008 Conceptos de manejo en situación de catástrofe (triage, extricación, inmo... 617
4.01.3.009 Conceptos generales de hipertensión portal 618
4.01.3.010 Conceptos generales del pre y post operatorio 618
4.01.3.011 Conceptos generales sobre injertos y colgajos 619
4.01.3.012 Diagnóstico precoz del cáncer mamario 619
4.01.3.013 Epidemiología del cáncer. 620
4.01.3.014 Evaluación nutricional 620
4.01.3.015 Ileostomías 621
4.01.3.016 Infección quirúrgica e intrahospitalaria 621
4.01.3.017 Manejo del dolor 622
4.01.3.018 Tratamiento antitetánico y antirrábico 622
4.01.4.001 Radiografía de tórax 623
4.01.4.002 Radiografía simple de abdomen 623
4.01.4.003 Radiografía de cráneo 624
4.01.4.004 Radiografía de columna cervical 624
4.01.4.005 Radiografía de columna dorsal y lumbar 625
4.01.4.006 Radiografía de pelvis y cadera 625
4.01.4.007 Radiografía de extremidades 626
4.01.4.008 Radiografías contrastadas (EED, tràsnito intestinal, enema baritada y piel... 626
4.01.4.009 Mamografía 627
4.01.4.010 TAC de tórax 627
4.01.4.011 Ecografía: distinguir vesícula y líquido intraabdominal 628
4.01.4.012 Hemograma, perfil bioquímico, pefil hepático. 628
4.01.4.013 Pruebas de coagulación 629
4.01.4.014 Gases arteriales y electrolitos plasmáticos 629
4.01.4.015 TAC de abdomen y pelvis 630
4.01.5.001 Anestesia local por infiltración 631
4.01.5.002 Anestesia troncular de dedos y ortejos 631
4.01.5.003 Anoscopía 631
4.01.5.004 Ayudantía quirúrgica (nociones básicas) 632
4.01.5.005 Instalación y cuidado de sonda Foley 632
4.01.5.006 Colonoscopía 633
4.01.5.007 Cricoidostomía 633
4.01.5.008 Curación básica de quemaduras 634
4.01.5.009 Curación de heridas, sutura y aseo 634
4.01.5.010 Denudación venosa 635
4.01.5.011 Drenaje de lesiones superficiales 635
4.01.5.012 Endoscopía digestiva alta 636
4.01.5.013 Evaluación pre y post-operatoria 636
4.01.5.014 Evaluación primaria en trauma 637
4.01.5.015 Evaluación secundaria en trauma 637
4.01.5.016 Fibrobroncoscopía 638
4.01.5.017 Hemostasia con ligaduras y taponamiento de heridas sangrantes 638
4.01.5.018 Intubación traqueal 639
4.01.5.019 Intubación nasogástrica 639
4.01.5.020 Inyecciones subcutáneas, intramusculares e intravenosas 640
4.01.5.021 Manejo de drenajes 640

4.01.5.022 Manejo de vía aérea y columna cervical en trauma 641
4.01.5.023 Manejo ventilatorio básico 641
4.01.5.024 Onicectomía 642
4.01.5.025 Paracentesis 642
4.01.5.026 Drenaje pleural 643
4.01.5.027 Punción venosa 643
4.01.5.028 Resucitación cardiorrespiratoria 644
4.01.5.029 Punción pleural 644
4.01.5.030 Traqueostomía y cricoidostomía 645
4.01.5.031 Traslado del traumatizado 645
4.01.5.032 Vendajes e inmovilizaciones con férulas 646

13 Traumatología

4.02.1.001 Artrosis primarias y secundarias 648
4.02.1.002 Displasia congénita de cadera 649
4.02.1.003 Escoliosis y deformidades vertebrales 650
4.02.1.004 Infecciones osteoarticulares 651
4.02.1.005 Lumbago mecánico 651
4.02.1.006 Lumbociática radicular 652
4.02.1.007 Pie plano 653
4.02.1.008 Síndrome de hombro doloroso 653
4.02.1.009 Tumores óseos 655
4.02.2.001 Complicaciones de los traumatismos: sistémicas y vasculares 658
4.02.2.002 Disyunción-fractura del niño 659
4.02.2.003 Esguince grado1 (acromioclavicular, dedos, rodilla y tobillo) 660
4.02.2.004 Fractura de cadera 660
4.02.2.005 Fractura de la muñeca 662
4.02.2.006 Fractura inestable de la pelvis 663
4.02.2.007 Fracturas de diáfisis y metáfisis 664
4.02.2.008 Fracturas expuestas 666
4.02.2.009 Heridas de la mano no complicadas 667
4.02.2.010 Lesiones de los nervios periféricos 667
4.02.2.011 Lesiones de partes blandas (contusiones, hematomas, desgarros) 668
4.02.2.012 Luxación del hombro 670
4.02.2.013 Luxofractura del tobillo 671
4.02.2.014 Politraumatizado 672
4.02.2.015 Trauma raquimedular 672
4.02.3.001 Accidentes del trabajo 673
4.02.3.002 Complicaciones de la inmovilización con yeso 673
4.02.3.003 Factores de riesgo de artrosis 674
4.02.3.004 Factores de riesgo de osteoporosis 675
4.02.3.005 Lumbociática radicular 675
4.02.3.006 Prevención de displasia de cadera (diagnóstico precoz) 676
4.02.3.007 Triage 676
4.02.4.001 Radiografía de columna vertebral 677
4.02.4.002 Radiografía de pelvis-caderas ante sospecha de fractura 677
4.02.4.003 Radiografía huesos largos ante sospecha de fractura 678
4.02.4.004 Radiografía de displasia cadera 678
4.02.4.005 Radiografía en tumores oseos 679
4.02.4.006 Set radiológico de trauma en conjunto (columna cervical, tórax, pelvis y c... 679
4.02.4.007 Citoquimico de líquido articular 680
4.02.4.008 Cultivo y antibiograma en infecciones osteoarticulares y heridas 680
4.02.4.009 Gram líquido articular 681
4.02.5.001 Inmovilizaciones de urgencia 681
4.02.5.002 Punción articular de rodilla 682
4.02.5.003 Reducción de luxaciones de codo, hombro e interfalángicas 682
4.02.5.004 Tracción de partes blandas 683
4.02.5.005 Traslado del traumatizado 683

14 Urología

4.03.1.001 Balanitis, balano postitis 686
4.03.1.002 Cáncer de próstata 686
4.03.1.003 Cáncer de vejiga y urotelio 688
4.03.1.004 Criptorquídea 689
4.03.1.005 Disfunción sexual de causa orgánica 689
4.03.1.006 Enfermedades de transmisión sexual 690
4.03.1.007 Epididimitis 691
4.03.1.008 Estenosis uretral 692
4.03.1.009 Fimosis, parafimosis 692
4.03.1.010 Hematuria 693
4.03.1.011 Hidrocele 694
4.03.1.012 Hidronefrosis 694
4.03.1.013 Hiperplasia prostática benigna 695
4.03.1.014 Incontinencia urinaria 696
4.03.1.015 Infección urinaria alta y baja 698
4.03.1.016 Infección urinaria específica 699
4.03.1.017 Infertilidad masculina 700
4.03.1.018 Lesiones quísticas del riñón 700
4.03.1.019 Malformaciones congénitas nefrourológicas 701
4.03.1.020 Quistes del epidídimo 701
4.03.1.021 Reflujo vésico ureteral 702
4.03.1.022 Tumor renal 702
4.03.1.023 Tumor suprarrenal 703
4.03.1.024 Tumor testicular 704
4.03.1.025 Urolitiasis 705
4.03.1.026 Uropatía alta 707
4.03.1.027 Uropatía obstructiva baja 707
4.03.1.028 Varicocele 708
4.03.2.001 Cólico renal 708
4.03.2.002 Hematuria masiva 710
4.03.2.003 Parafimosis 711
4.03.2.004 Priapismo 711
4.03.2.005 Prostatis aguda 712
4.03.2.006 Retención urinaria aguda 713
4.03.2.007 Torsión testicular 714
4.03.2.008 Trauma urológico 716
4.03.2.009 Traumatismo uretral 717
4.03.3.001 Epidemiología del cáncer de próstata 718
4.03.3.002 Epidemiología del adenoma de próstata 718
4.03.3.003 Epidemiologia del cáncer testicular 718
4.03.3.004 Factores de riesgo y prevención de ETS 719
4.03.3.005 Screening de cáncer de próstata 719
4.03.3.006 Trasplante renal, indicaciones y complicaciones 720
4.03.4.001 Radiografía renal y vesical simple 720
4.03.4.002 Pielografía de eliminación 721
4.03.4.003 Pielo TAC 721
4.03.4.004 TAC de abdomen y pelvis 722
4.03.4.005 Uretrocistografía 722
4.03.4.006 Ecografía renal (tamaño, asimetrías, hidronefrosis) 723
4.03.4.007 Ecotomografía de vejiga y próstata 723
4.03.4.008 Ecotomografía testicular 724
4.03.4.009 Cintigrama renal 724
4.03.4.010 Antígeno prostático específico 725
4.03.4.011 Examen de orina completo, urocultivo 725
4.03.4.012 Urodinamia 726
4.03.4.013 Uroflujometría 726
4.03.5.001 Biopsia prostática 727
4.03.5.002 Cistoscopia 727
4.03.5.003 Cistostomía abierta 728
4.03.5.004 Cistostomía por punción 728
4.03.5.005 Instalación y cuidado de sonda Foley 729
4.03.5.006 Reducción de parafimosis 729

15 Psiquiatría

5.01.1.001 Trastorno de pánico con o sin agorafobia 732
5.01.1.002 Trastorno obsesivo compulsivo 736
5.01.1.003 Trastornos fóbicos (fobia social y fobia específica) 738
5.01.1.004 Trastorno de adaptación 740
5.01.1.005 Trastorno agudo por estrés 742
5.01.1.006 Trastorno por estrés postraumático 743
5.01.1.007 Primer episodio depresivo 744
5.01.1.008 Trastorno depresivo (recurrente) 747
5.01.1.009 Trastorno bipolar 748
5.01.1.010 Esquizofrenia y otros trastornos psicòticos 751
5.01.1.011 Consumo perjudicial de alcohol y drogas 759
5.01.1.012 Dependencia de alcohol 760
5.01.1.013 Dependencia de otras drogas 761
5.01.1.014 Delirium 762
5.01.1.015 Trastornos neurocognitivos 763
5.01.1.016 Trastornos de la personalidad 764
5.01.1.017 Disfunción sexual 766
5.01.1.018 Trastornos de la conducta alimentaria 766
5.01.1.019 Sexualidad humana y sus alteraciones 768
5.01.1.020 Trastornos somatomorfos 769
5.01.1.021 Trastornos disociativos 770
5.01.1.022 Trastornos facticios 772
5.01.1.023 Trastorno del espectro autista 774
5.01.1.024 Trastorno específico del aprendizaje escolar 775
5.01.1.025 Retardo mental 775
5.01.1.026 Enuresis 776
5.01.1.027 Encopresis 776
5.01.1.028 Trastorno por déficit atencional 777
5.01.1.029 Intento de suicidio en niños y adolescentes 778
5.01.1.030 Trastorno conducta oposicionista desafiante 779
5.01.1.031 Trastorno conducta disocial 779
5.01.1.032 Trastorno somatización en niños 780
5.01.1.033 Trastornos ansiosos en niños 780
5.01.1.034 Trastornos del ánimo en niños 781
5.01.1.035 Consumo perjudicial de drogas en niños y adolescentes 782
5.01.1.036 Trastorno de ansiedad generalizada 782
5.01.2.001 Conducta suicida 784
5.01.2.002 Agitación psicomotora 784
5.01.2.003 Intoxicación por sustancias psicoactivas 785
5.01.3.001 Clasificaciones en psiquiatría 786
5.01.3.002 Conducta suicida 787
5.01.3.003 Desarrollo cognitivo, afectivo y social a lo largo del ciclo vital 787
5.01.3.004 Higiene de la alimentación 788

5.01.3.005 Higiene del sueño 788
5.01.3.006 Disforia de género 789
5.01.3.007 Maltrato en el adulto mayor 789
5.01.3.008 Maltrato infantil 790
5.01.3.009 Nociones de psiquiatría forense 790
5.01.3.010 Personalidad: Concepto y medición. Principales teorías en psicología de l... 791
5.01.3.011 Prevención: Alcohol, tabaco, drogas. Modelo de prevención primaria. 791
5.01.3.012 Respuesta sexual humana 792
5.01.3.013 Violencia intrafamiliar 792
5.01.4.001 Estudio de hormonas tiroídeas 793
5.01.4.002 Exámenes de orina para el control de drogas de abuso 793
5.01.4.003 Niveles plasmáticos de estabilizadores del ánimo 794
5.01.4.004 Tests WAIS y WISC 794
5.01.5.001 EBBA (Escala breve de Beber Anormal) 795
5.01.5.002 Examen físico y neurológico: control de neurolépticos de depósito 795
5.01.5.003 Intervención en crisis 796
5.01.5.004 Mini mental test, MoCA test 797

16 Dermatología

6.01.1.001 Acné 799
6.01.1.002 Alopecías 799
6.01.1.003 Cáncer de piel no melanoma (carcinoma basocelular y espinocelular) 800
6.01.1.004 Dermatitis atópica 802
6.01.1.005 Dermatitis del pañal 802
6.01.1.006 Dermatitis seborreica infantil y del adulto 803
6.01.1.007 Dermitis de contacto 803
6.01.1.008 Enfermedades de transmisión sexual 803
6.01.1.009 Eritema nodoso / Eritema indurado de Bazin 804
6.01.1.010 Eritema polimorfo menor 804
6.01.1.011 Fotodermatosis 805
6.01.1.012 Granuloma piogénico 806
6.01.1.013 Hemangiomas cutáneos infantiles 806
6.01.1.014 Linfomas cutáneos 807
6.01.1.015 Líquen plano 807
6.01.1.016 Lupus eritematoso cutáneo crónico (lupus discoide) 808
6.01.1.017 Melanoma maligno 808
6.01.1.018 Micosis superficiales 809
6.01.1.019 Pediculosis 810
6.01.1.020 Pénfigo 811
6.01.1.021 Piodermias superficiales y profundas (no linfáticas) 811
6.01.1.022 Pitiriasis Rosada de Gilbert 812
6.01.1.023 Prúrigo infantil agudo, picadura de insectos 813
6.01.1.024 Psoriasis 813
6.01.1.025 Reacciones cutáneas por drogas (rush, toxidermia fija) 814
6.01.1.026 Rosácea 815
6.01.1.027 Sarna 815
6.01.1.028 Tumores benignos de piel (quistes, lipomas, queratosis seborreica) 817
6.01.1.029 Tumores premalignos (queratosis actínicas, Bowen) 817
6.01.1.030 Urticaria aguda 818
6.01.1.031 Verrugas, herpes simplex, herpes zoster, moluscos 819
6.01.1.032 Vitiligo 820
6.01.1.033 Vasculitis cutáneas 821
6.01.2.001 Angioedema de Quinque 821
6.01.2.002 Ántrax 822
6.01.2.003 Erisipela / Celulitis 822
6.01.2.004 Eritrodermia 823
6.01.2.005 Fasceitis necrotizante 823
6.01.2.006 Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido 824
6.01.2.007 Herpes zoster 824
6.01.2.008 Loxocelismo 825
6.01.2.009 Necrolisis tóxica epidérmica 826
6.01.2.010 Pénfigo y penfigoide 827
6.01.2.011 Quemadura solar 828
6.01.2.012 Sífilis congénita 828
6.01.2.013 Síndrome de hipersensibilidad a drogas 829
6.01.2.014 Síndrome de piel escaldada por estafilococos 830
6.01.2.015 Síndrome de Stevens-Johnson 830
6.01.2.016 Urticaria y angioedema 831
6.01.3.001 Fotoprotección 831
6.01.3.002 Higiene de la vivienda y profilaxis del loxoscelismo 832
6.01.3.003 Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas 832
6.01.4.001 Acarotest 833
6.01.4.002 Dermatoscopía 833
6.01.4.003 Gram y cultivo 834
6.01.4.004 Micológico directo de piel, pelos y uñas 834
6.01.4.005 Patch test 835
6.01.4.006 Test TZANCK 835
6.01.4.007 VDRL - MHATP 836
6.01.5.001 Biopsia de piel 836

17 Oftalmología

6.02.1.001 Ametropía 839
6.02.1.002 Blefaritis 839
6.02.1.003 Catarata 840
6.02.1.004 Chalazion 841
6.02.1.005 Conjuntivitis bacteriana aguda 842
6.02.1.006 Conjuntivitis bacteriana crónica 842
6.02.1.007 Conjuntivitis no infecciosa 843
6.02.1.008 Conjuntivitis viral no complicada 843
6.02.1.009 Dacriocistitis aguda 844
6.02.1.010 Degeneración macular relacionada a la edad 844
6.02.1.011 Estrabismo 846
6.02.1.012 Glaucoma congénito 846
6.02.1.013 Glaucoma crónico 847
6.02.1.014 Hifema 848
6.02.1.015 Leucoma corneal 849
6.02.1.016 Neuritis óptica 850
6.02.1.017 Neuropatía óptica isquémica 851
6.02.1.018 Obstrucción completa de la vía lacrimal 852
6.02.1.019 Orzuelo no complicado 852
6.02.1.020 Pterigion 853
6.02.1.021 Queratitis 853
6.02.1.022 Retinopatía del prematuro 854
6.02.1.023 Retinopatía diabética 855
6.02.1.024 Síndrome de ojo seco 856
6.02.1.025 Tumores de conjuntiva 856
6.02.1.026 Tumores de la vía óptica 857
6.02.1.027 Tumores de órbita 857
6.02.1.028 Tumores de párpado 858
6.02.1.029 Tumores endoculares (retinoblastoma y otros) 858
6.02.1.030 Uveítis anterior o posterior 859
6.02.1.031 Vicios de refracción en personas de 65 años o más 861
6.02.2.001 Causticaciones oculares 861
6.02.2.002 Contusión ocular 862
6.02.2.003 Desprendimiento de retina 863
6.02.2.004 Disminución de la visión (lenta vs súbita) 864
6.02.2.005 Glaucoma agudo 865
6.02.2.006 Hemorragia vítrea 867
6.02.2.007 Herida penetrante o perforante ocular 868
6.02.2.008 Heridas de párpados 869
6.02.2.009 Parálisis III par + midriasis 869
6.02.2.010 Úlcera corneal 870
6.02.3.001 Accidentes del trabajo 870
6.02.3.002 Diabetes 871
6.02.3.003 Examen visual en adulto 871
6.02.3.004 Examen visual preventivo en niños 872
6.02.3.005 Hipertensión arterial 872
6.02.3.006 Orbitopatía tiroidea 873
6.02.4.001 Campo visual 873
6.02.4.002 Cultivo de secreción conjuntival 874
6.02.5.001 Aplicación de ungüentos 874
6.02.5.002 Campo visual por confrontación 875
6.02.5.003 Colocación de sello ocular 875
6.02.5.004 Cover test 876
6.02.5.005 Eversión palpebral 876
6.02.5.006 Examen de rojo pupilar con oftalmoscopio 877
6.02.5.007 Extracción de cuerpo extraño tarsal 877
6.02.5.008 Extracción de pestañas distiquiásicas 878
6.02.5.009 Instilación de colirios 878
6.02.5.010 Oftalmoscopía directa 879
6.02.5.011 Reflejos pupilares 879
6.02.5.012 Tensión ocular palpatoria 880
6.02.5.013 Test de Hirschberg (imagen especular de la córnea) 880
6.02.5.014 Toma de visión 881

18 Otorrinolaringología

6.03.1.001 Alergia nasosinusal 883
6.03.1.002 Amigdalitis aguda 883
6.03.1.003 Amigdalitis crónica 883
6.03.1.004 Cáncer de boca, labios y orofaringe 884
6.03.1.005 Cáncer laríngeo e hipofaríngeo 884
6.03.1.006 Cáncer nasosinusal 885
6.03.1.007 Diagnóstico diferencial de hipoacusias de transmisión 886
6.03.1.008 Diagnóstico diferencial de hipoacusias sensorioneurales 886
6.03.1.009 Disfonías agudas 887
6.03.1.010 Disfonías crónicas 887
6.03.1.011 Epistaxis a repetición 888
6.03.1.012 Epistaxis leve 889
6.03.1.013 Estridor laríngeo 889
6.03.1.014 Hipoacusia neonatal 889
6.03.1.015 Masa cervical 890
6.03.1.016 Obstrucción nasal crónica 891
6.03.1.017 Odinofagias agudas 891
6.03.1.018 Odinofagias crónicas 892
6.03.1.019 Otitis externa 892
6.03.1.020 Otitis media aguda 894
6.03.1.021 Otitis media con efusión 894

6.03.1.022 Otitis media crónica y complicaciones 895
6.03.1.023 Patología de glándulas salivales 897
6.03.1.024 Poliposis nasal 898
6.03.1.025 Rinorrea crónica 899
6.03.1.026 Rinorreas agudas 899
6.03.1.027 Síndrome de apnea del sueño 900
6.03.1.028 Síndrome respirador bucal 900
6.03.1.029 Síndrome vertiginoso 901
6.03.1.030 Sinusopatías crónicas 902
6.03.1.031 Tinitus 903
6.03.1.032 Trastorno de deglución 903
6.03.1.033 Trastornos de habla y lenguaje 903
6.03.2.001 Absceso mastoídeo de otitis media aguda y crónica 904
6.03.2.002 Absceso periamigdalino 904
6.03.2.003 Absceso profundo de cuello 905
6.03.2.004 Absceso retrofaríngeo 906
6.03.2.005 Atresia coanal congénita 906
6.03.2.006 Barotrauma ótico y trauma acústico agudo 907
6.03.2.007 Cuerpo extraño en el oído 907
6.03.2.008 Cuerpo extraño en el esófago 908
6.03.2.009 Cuerpo extraño en vía aérea 908
6.03.2.010 Cuerpo extraño nasal 909
6.03.2.011 Epistaxis masiva 909
6.03.2.012 Fractura nasal reciente 910
6.03.2.013 Hematoma nasoseptal 910
6.03.2.014 Otohematoma 911
6.03.2.015 Otorragia 911
6.03.2.016 Perforación timpánica traumática 912
6.03.2.017 Síndrome vertiginoso agudo 912
6.03.2.018 Sordera súbita 913
6.03.3.001 Detección de hipoacusia y sordera en niños 914
6.03.3.002 Pesquisa de trastornos del lenguaje 914
6.03.3.003 Prevención de alergias nasosinusales 915
6.03.3.004 Prevención de cáncer laríngeo 915
6.03.3.005 Prevención de cuerpo extraño en niños 916
6.03.3.006 Prevención de otitis externa 916
6.03.3.007 Prevención de trauma acústico y daño por exposición a ruidos 917
6.03.4.001 Radiografía de cavidades perinasales 917
6.03.4.002 Radiografía de cavum 918
6.03.4.003 TAC de cavidades perinasales 918
6.03.4.004 TAC cervical con contraste 919
6.03.4.005 TAC de oídos sin medio de contraste 919
6.03.4.006 Audiometría básica 920
6.03.4.007 Emisiones otoacústicas 920
6.03.4.008 Impedanciometría básica 921
6.03.4.009 Polisomnografía 921
6.03.4.010 Pruebas cutáneas de alergia 921
6.03.4.011 Estudio de VIII par 922
6.03.5.001 Drenaje de absceso mastoídeo 922
6.03.5.002 Drenaje de absceso periamigdaliano 923
6.03.5.003 Drenaje de absceso retrofaríngeo 923
6.03.5.004 Drenaje de hematoma nasoseptal 924
6.03.5.005 Drenaje de otohematoma 924
6.03.5.006 Extracción de cuerpo extraño del oído 924
6.03.5.007 Extracción de cuerpo extraño nasal 925
6.03.5.008 Intubacion traqueal 925
6.03.5.009 Laringoscopía indirecta 926
6.03.5.010 Lavado de oídos 926
6.03.5.011 Maniobra de Heimlich 926
6.03.5.012 Taponamiento nasal anterior 927
6.03.5.014 Taponamiento nasal posterior 927
6.03.5.015 Traqueostomía y cricoidostomía 928

19 Pediatría

2.01.1.001 Desnutrición 930
2.01.1.002 Dislipidemias 930
2.01.1.003 Obesidad 931
2.01.1.004 Adenitis cervical 931
2.01.1.005 Celulitis periorbitaria 931
2.01.1.006 Coqueluche 932
2.01.1.007 Enteroparasitosis 933
2.01.1.008 Escarlatina 934
2.01.1.009 Exantemas virales 935
2.01.1.010 Hepatitis viral 939
2.01.1.011 Infecciones de piel y partes blandas 940
2.01.1.012 Infecciones por HIV 941
2.01.1.013 Infecciones por Salmonella 941
2.01.1.014 Infecciones recurrentes 942
2.01.1.015 Meningoencefalitis/ Meningitis bacteriana aguda 942
2.01.1.016 Mononucleosis infecciosa 943
2.01.1.017 Síndrome febril agudo sin foco 944
2.01.1.018 Síndrome febril prolongado 945
2.01.1.019 Asma bronquial 945
2.01.1.020 Bronquiolitis 946
2.01.1.021 Enfermedad pulmonar crónica 947
2.01.1.022 Estridor 947
2.01.1.023 Faringoamigdalitis 948
2.01.1.024 Infecciones respiratorias agudas bajas y sus complicaciones 949
2.01.1.025 Laringitis 952
2.01.1.026 Otitis media 953
2.01.1.027 Resfrío común 953
2.01.1.028 Síndrome bronquial obstructivo 954
2.01.1.029 Sinusitis 954
2.01.1.030 Adenopatías 955
2.01.1.031 Anemia ferropriva 956
2.01.1.032 Leucemias 956
2.01.1.033 Linfomas 958
2.01.1.034 Neutropenia febril 958
2.01.1.035 Síndrome purpúrico 958
2.01.1.036 Trastornos coagulación 960
2.01.1.037 Tumores sólidos 961
2.01.1.038 Constipación 962
2.01.1.039 Diarrea aguda y en vías de prolongación 963
2.01.1.040 Diarrea crónica 965
2.01.1.041 Dolor abdominal recurrente 965
2.01.1.042 Fibrosis quística 966
2.01.1.043 Hemorragia digestiva 967
2.01.1.044 Hepatomegalia 968
2.01.1.045 Insuficiencia hepática aguda 969
2.01.1.046 Displasia broncopulmonar / Reflujo gastroesofágico y vómitos del lactant... 969
2.01.1.047 Síndrome disentérico 970
2.01.1.048 Síndrome malabsorción 971
2.01.1.049 Arritmias 971
2.01.1.050 Cardiopatías congénitas frecuentes 972
2.01.1.051 Endocarditis infecciosa 974
2.01.1.052 Insuficiencia cardíaca 974
2.01.1.053 Síncope 975
2.01.1.054 Soplos 975
2.01.1.055 Alergias 976
2.01.1.056 Inmunodeficiencias 977
2.01.1.057 Mesenquimopatías 977
2.01.1.058 Vasculitis: PSH, Kawasaki, otros 978
2.01.1.059 Enuresis 982
2.01.1.060 Hematuria 982
2.01.1.061 Hipertensión arterial 983
2.01.1.062 Infección urinaria 983
2.01.1.063 Insuficiencia renal aguda 986
2.01.1.064 Insuficiencia renal crónica 986
2.01.1.065 Malformaciones urogenitales 987
2.01.1.066 Síndrome edematoso 987
2.01.1.067 Síndrome hemolítico urémico 988
2.01.1.068 Síndrome nefrítico 989
2.01.1.069 Síndrome nefrótico 989
2.01.1.070 Trastornos del equilibrio ácido-base 990
2.01.1.071 Trastornos hidro-electrolíticos 991
2.01.1.072 Alteraciones del desarrollo puberal 991
2.01.1.073 Diabetes 993
2.01.1.074 Hiperplasia suprarrenal congénita 994
2.01.1.075 Hipotiroidismo 996
2.01.1.076 Talla baja 997
2.01.1.077 Cefalea 998
2.01.1.078 Encefalopatía hipóxico-isquémica 999
2.01.1.079 Macro y microcefalia 1000
2.01.1.080 Retraso del desarrollo SM 1000
2.01.1.081 Síndrome convulsivo 1000
2.01.1.082 Síndrome déficit atencional 1001
2.01.1.083 Síndrome hipertónico 1002
2.01.1.084 Síndrome hipotónico 1002
2.01.1.085 Trastornos aprendizaje 1003
2.01.1.086 Trastornos del lenguaje 1003
2.01.1.087 Tumores SNC 1004
2.01.1.088 Criptorquidia 1004
2.01.1.089 Fimosis 1005
2.01.1.090 Hernia inguinal 1005
2.01.1.091 Alteraciones de los pies 1006
2.01.1.092 Displasia de caderas 1006
2.01.1.093 Infecciones osteoarticulares 1007
2.01.1.094 Patología de columna 1008
2.01.1.095 Conjuntivitis aguda 1008
2.01.1.096 Estrabismo 1010
2.01.1.097 Ojo rojo 1010
2.01.1.098 Vicios de refracción 1011
2.01.1.099 Epistaxis 1011
2.01.1.100 Hipertrofia adenoidea/amigdalina 1012
2.01.1.101 Hipoacusia 1012
2.01.1.102 Otitis media recurrente 1013
2.01.1.103 Rinitis alérgica 1013
2.01.1.104 Acné 1014
2.01.1.105 Alteraciones pigmentarias 1015
2.01.1.106 Candidiasis urogenital 1015

2.01.1.107 Dermatitis atópica 1016
2.01.1.108 Dermatitis del pañal y de contacto 1016
2.01.1.109 Ectoparasitosis 1017
2.01.1.110 Infecciones micóticas de piel y fanéreos 1018
2.01.1.111 Malformaciones vasculares cutáneas 1018
2.01.1.112 Alteraciones de la termorregulación 1019
2.01.1.113 Apneas 1020
2.01.1.114 Asfixia neonatal 1020
2.01.1.115 Convulsiones neonatales 1021
2.01.1.116 Enterocolitis necrotizante (ECN) 1021
2.01.1.117 Estridor congénito 1022
2.01.1.118 Hijo madre diabética 1023
2.01.1.119 Hipocalcemia 1023
2.01.1.120 Hipoglicemia 1024
2.01.1.121 Ictericia neonatal y del primer trimestre 1024
2.01.1.122 Poliglobulia 1027
2.01.1.123 Prematurez 1027
2.01.1.124 Sepsis neonatal 1028
2.01.1.125 Síndrome aspirativo meconial 1029
2.01.1.126 Síndrome distress respiratorio 1029
2.01.1.127 TORCH 1030
2.01.1.128 RN PEG-GEG 1031
2.01.1.129 Alteraciones menstruales 1032
2.01.1.130 Leucorrea y vulvovaginitis 1033
2.01.1.131 Sinequias vulvares 1033
2.01.1.132 Dismorfias 1034
2.01.1.133 Malformaciones congénitas más frecuentes 1035
2.01.1.134 Trisomía 21 1036
2.01.1.136 Depresión 1036
2.01.1.137 Ideación suicida 1037
2.01.1.138 Maltrato infantil 1037
2.01.1.139 Trastornos de alimentación 1038
2.01.1.140 Trastornos de ansiedad generalizada 1038
2.01.1.141 Trastornos del desarrollo 1039
2.01.1.142 Trastornos neuropsiquiátricos 1040
2.01.1.143 Artritis idiopática juvenil 1040
2.01.2.001 Abdomen agudo 1041
2.01.2.002 Absceso amigdalino 1041
2.01.2.003 Aspiración cuerpo extraño 1042
2.01.2.004 Compromiso de conciencia 1043
2.01.2.005 Crisis bronquial obstructiva 1043
2.01.2.006 Deshidratación 1044
2.01.2.007 Emergencia hipertensiva 1045
2.01.2.008 Epistaxis 1046
2.01.2.009 Fracturas 1046
2.01.2.010 Hemorragia digestiva 1047
2.01.2.011 Hipertensión endocraneana 1047
2.01.2.012 Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar 1048
2.01.2.013 Insuficiencia respiratoria aguda 1048
2.01.2.014 Intoxicaciones 1049
2.01.2.015 Meningitis bacteriana 1050
2.01.2.016 Meningococcemia 1051
2.01.2.017 Muerte súbita-ALTE, BRUE 1052
2.01.2.018 Obstrucción de vía aérea superior 1052
2.01.2.019 Obstrucción intestinal 1053
2.01.2.020 Paro cardiorrespiratorio 1054
2.01.2.021 Politraumatismos 1054
2.01.2.022 Quemaduras 1055
2.01.2.023 Shock 1055
2.01.2.024 Síndrome convulsivo 1056
2.01.2.025 Testículo agudo 1056
2.01.2.026 Traumatismo encéfalo- craneano 1057
2.01.2.027 Estatus convulsivo en el niño 1057
2.01.2.144 SARS Cov 2 COVID 19 1058
2.01.3.001 Alimentación normal 1058
2.01.3.002 Desarrollo psico-motor 1059
2.01.3.003 Diagnóstico nutricional 1060
2.01.3.004 Entrevista y comunicación efectiva 1061
2.01.3.005 Familia y ciclo vital 1061
2.01.3.006 Inmunizaciones en Chile (PNI y extra PNI) 1062
2.01.3.007 Lactancia materna 1066
2.01.3.008 Prevención de accidentes 1066
2.01.3.009 Prevención de conductas de riesgo 1067
2.01.3.010 Prevención de maltrato y abuso infantil 1067
2.01.3.011 Promoción de salud y estilos de vida saludables 1068
2.01.3.012 Psiquiatría de enlace 1068
2.01.3.013 Relación médico-paciente-familia 1069
2.01.3.014 Salud infantil en Chile y el mundo 1069
2.01.3.015 Salud oral 1070
2.01.3.016 Supervisión de salud- adolescente 1070
2.01.3.017 Supervisión de salud- escolar 1071
2.01.3.018 Supervisión de salud- lactante 1071
2.01.3.019 Supervisión de salud- pre-escolar 1072
2.01.4.001 Radiografía de tórax 1072
2.01.4.002 Radiografía de abdomen simple 1073
2.01.4.003 Ecotomografía abdominal 1073
2.01.4.004 Radiografía de cavum 1074
2.01.4.005 Radiografía de cráneo 1074
2.01.4.006 Radiografía de edad ósea 1075
2.01.4.007 Radiografía de pelvis anteroposterior 1075
2.01.4.008 Radiografía de senos paranasales 1076
2.01.4.009 Radiografía esófago- estómago- duodeno 1076
2.01.4.010 Citoquímico de líquido cefaloraquídeo y pleural 1077
2.01.4.011 Cultivos y antibiograma 1077
2.01.4.012 Electrocardiograma 1078
2.01.4.013 Electrolitos plasmáticos 1078
2.01.4.014 Gases en sangre arterial 1079
2.01.4.015 Hemograma 1079
2.01.4.016 Orina completa 1080
2.01.4.017 Parasitológico de deposiciones 1080
2.01.4.018 Perfil bioquímico 1081
2.01.4.019 Perfil lipídico 1081
2.01.4.020 Proteína C reactiva cuantitativa 1082
2.01.4.021 Pruebas de coagulación 1082
2.01.4.022 Pruebas de función renal 1083
2.01.4.023 Pruebas hepáticas 1083
2.01.4.024 Pruebas tiroideas 1084
2.01.4.025 Serología y técnicas de aislamiento viral y bacteriano 1084
2.01.4.026 Test del sudor 1085
2.01.5.001 Antropometría en la edad pediátrica 1085
2.01.5.002 Atención inmediata del recién nacido 1086
2.01.5.003 Cateterismo vesical 1086
2.01.5.004 Maniobra de Heimlich 1087
2.01.5.005 Osteoclisis 1087
2.01.5.006 Oxigenoterapia 1088
2.01.5.007 Proctoclisis 1088
2.01.5.008 Punción lumbar 1089
2.01.5.009 Punción pleural 1089
2.01.5.010 Punción suprapúbica 1090
2.01.5.011 Reanimación neonatal 1090
2.01.5.012 Reanimación cardiopulmonar pediátrica 1091

20 Obstetricia y Ginecología

3.01.1.001 Aborto espontáneo 1094
3.01.1.002 Anemia y embarazo 1095
3.01.1.003 Colestasia gravídica 1096
3.01.1.004 Diabetes y embarazo 1097
3.01.1.005 Embarazo con edad gestacional dudosa 1099
3.01.1.006 Embarazo ectópico no complicado 1099
3.01.1.007 Embarazo múltiple 1102
3.01.1.008 Enfermedad del trofoblasto 1103
3.01.1.009 Macrosomía fetal 1105
3.01.1.010 Restricción de crecimiento fetal 1106
3.01.1.011 Síndrome hipertensivo del embarazo 1108
3.01.1.012 Amenorrea 1111
3.01.1.013 Cáncer cervicouterino 1113
3.01.1.014 Dolor pelviano y dismenorrea 1114
3.01.1.015 Endometriosis 1114
3.01.1.016 Enfermedad preinvasora del cuello uterino-Lesiones genitales intraepite... 1116
3.01.1.017 Enfermedades de transmisión sexual 1119
3.01.1.018 Hemorragia genital anormal 1120
3.01.1.019 Infecciones genitourinarias 1122
3.01.1.020 Infertilidad conyugal 1125
3.01.1.021 Mioma uterino 1126
3.01.1.022 Oligoanovulación crónica 1128
3.01.1.023 Patología benigna del endometrio (hiperplasia, pólipos...) 1129
3.01.1.024 Patología maligna del endometrio 1130
3.01.1.025 Proceso inflamatorio pelviano 1131
3.01.1.026 Prolapso genital 1132
3.01.1.027 Síndrome climatérico y menopausia 1133
3.01.1.028 Tumores ováricos 1136
3.01.1.029 Patología benigna de mama 1138
3.01.1.030 Cáncer de mama 1138
3.01.1.031 VIH en ginecobstetricia 1139
3.01.1.032 Incontinencia urinaria 1140
3.01.2.001 Aborto provocado 1140
3.01.2.002 Absceso glándula de Bartolino 1141
3.01.2.003 Crisis hipertensiva del embarazo 1142
3.01.2.004 Eclampsia 1143
3.01.2.005 Embarazo ectópico complicado 1144
3.01.2.006 Endometritis puerperal 1145
3.01.2.007 Hiperemesis gravídica 1146
3.01.2.008 Hemorragia genital aguda (metrorragia disfuncional-cervicorragia por Cá... 1147
3.01.2.009 Mastitis puerperal 1149
3.01.2.010 Metrorragia: Desprendimiento previo de placenta normoinserta (DPPNI) 1150
3.01.2.011 Metrorragia: placenta previa 1151
3.01.2.012 Parto prematuro 1152
3.01.2.013 Presentaciones fetales anómalas 1155
3.01.2.014 Rotura prematura de membranas 1156
3.01.2.015 Rotura uterina 1159

3.01.2.016 Dolor pélvico agudo 1160
3.01.2.017 Sufrimiento fetal agudo 1161
3.01.2.018 Pelviperitonitis 1163
3.01.2.019 Quiste ovárico torcido 1163
3.01.2.020 Mastitis abscedada 1165
3.01.2.021 Trabajo parto distócico 1166
3.01.3.001 Control prenatal 1168
3.01.3.002 Derechos y aspectos legales de la embarazada y su pareja 1169
3.01.3.003 Determinación de edad gestacional 1170
3.01.3.004 Lactancia 1170
3.01.3.005 Manejo de la salud de la mujer climatérica 1171
3.01.3.006 Métodos naturales para la regulación de la fecundidad 1171
3.01.3.007 Mortalidad perinatal y materna 1172
3.01.3.008 Anticoncepción 1172
3.01.3.009 Prevención de enfermedad hemolítica perinatal 1175
3.01.3.010 Prevención de enfermedades de transmisión sexual 1175
3.01.3.011 Pubertad (adolescencia) 1176
3.01.3.012 Salud pública perinatal 1176
3.01.3.013 Screening ginecológico: Papanicolau, mamografía 1177
3.01.3.014 Sexualidad, género y diversidad 1177
3.01.3.015 Síndrome de ovario poliquístico 1178
3.01.3.016 Vínculo y apego 1178
3.01.4.001 Histerosalpingografía 1179
3.01.4.002 Mamografía 1179
3.01.4.003 Ecotomografía obstétrica normal 1180
3.01.4.004 Ecotomografía obstétrica patológica 1181
3.01.4.005 Ecotomografía ginecológica 1182
3.01.4.006 Ecotomografía mamaria 1182
3.01.4.007 Papanicolau 1183
3.01.4.008 HCG cuantitativa 1183
3.01.5.001 Amniocentesis 1184
3.01.5.002 Cesárea 1184
3.01.5.003 Doppler materno-fetal 1185
3.01.5.004 Drenaje abceso glándula Bartolino 1186
3.01.5.005 Evaluación anteparto 1186
3.01.5.006 Evaluación intraparto 1187
3.01.5.007 Examen ginecológico, especuloscopia y tacto bimanual 1187
3.01.5.008 Flujo vaginal (pH) 1188
3.01.5.009 Monitorizacion fetal (estresante y no estresante) 1188
3.01.5.010 Parto normal 1189
3.01.5.011 Perfil biofisico fetal 1190
3.01.5.012 Prueba de trabajo de parto 1190
3.01.5.013 Taponaje vaginal 1191
3.01.5.014 Toma de Papanicolau (incluye hacer el frotis) 1192

21 Salud Pública

7.01.3.001 Conceptos y definiciones de Salud Pública 1194
7.01.3.002 Funciones esenciales de la Salud Pública 1194
7.01.3.003 Historia natural de la enfermedad 1194
7.01.3.004 Niveles de prevención 1195
7.01.3.005 Promoción de salud y prevención de enfermedades 1197
7.01.3.006 Determinantes del nivel de salud 1198
7.01.3.007 Demografía y salud pública 1198
7.01.3.008 Diagnóstico de situación de salud: 1200
7.01.3.009 Indicadores de nivel de salud: cálculo e interpretación 1200
7.01.3.010 Etapas del diagnóstico de situación de salud 1203
7.01.3.011 Fuentes de información para el diagnóstico 1204
7.01.3.012 Ejecución de un diagnóstico 1204
7.01.3.013 Concepto y campo de la epidemiología 1205
7.01.3.014 Epidemiología descriptiva 1205
7.01.3.015 Usos de la epidemiología en el control de enfermedades 1206
7.01.3.016 Vigilancia epidemiológica y estudio de brotes 1207
7.01.3.017 Usos de la epidemiología en el diagnóstico de situación de salud 1209
7.01.3.018 Epidemiología analítica 1209
7.01.3.019 Medidas de asociación e impacto 1210
7.01.3.020 Diseños de investigación epidemiológica 1211
7.01.3.021 Estudios de prevalencia 1212
7.01.3.022 Estudios de casos y controles 1212
7.01.3.023 Estudios de cohortes 1213
7.01.3.024 Estudios experimentales y cuasiexperimentales 1214
7.01.3.025 Concepto de estudios ecológicos 1215
7.01.3.026 Causalidad y sesgos 1215
7.01.3.027 Investigación epidemiológica 1217
7.01.3.028 Pruebas de screening (tamizaje) y diagnósticas 1218
7.01.3.029 Descripción sistemática de problemas 1219
7.01.3.030 Criterios de priorización de problemas 1220
7.01.3.031 Estrategias de control de enfermedades infecciosas 1220
7.01.3.032 Estrategias de control de enfermedades crónicas prioritarias (cáncer, ca... 1221
7.01.3.033 Bases conceptuales de la seguridad social 1221
7.01.3.034 Desarrollo histórico de seguridad social y atención de salud 1222
7.01.3.035 Funciones de los sistemas de atención de salud 1222
7.01.3.036 Organización actual del sistema de salud chileno 1223
7.01.3.037 Política sanitaria y objetivos sanitarios en Chile 1223
7.01.3.038 Definición, estructura y funciones de los subsistemas en Chile 1224
7.01.3.039 Concepto y descripción de la red asistencial chilena 1224
7.01.3.040 Beneficios de la seguridad social y rol del médico en su acceso 1225
7.01.3.041 Conceptos de administración y gestión 1226
7.01.3.042 Planificación y programación en salud 1227
7.01.3.043 Formulación de programas 1227
7.01.3.044 Organización: principios y características estructurales y funcionales de ... 1228
7.01.3.045 Dirección: funciones de la dirección, liderazgo, comunicaciones, coordin... 1228
7.01.3.046 Evaluación y control: conceptos, tipos de evaluación 1229
7.01.3.047 Auditoría y acreditación 1229
7.01.3.049 Financiamiento del sector salud 1230
7.01.3.050 Rol del médico en la generación y uso de la información 1231
7.01.3.051 Certificado de defunción, licencia médica, notificación de enfermedades 1231
7.01.3.052 Ejercicio profesional: marcos ético, legal y gremial 1233
7.01.3.053 Derecho GES a atención integral de salud en agresión sexual aguda 1234
7.01.3.054 Otorgamiento, uso y sanciones por mal uso de licencias médicas 1234
7.01.3.055 Conceptos básicos de administración de establecimientos de salud 1235
7.01.3.056 Conocimiento de los derechos y deberes del paciente 1235

01
CARDIOLOGÍA

61 CÓDIGOS

195 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	24
Situaciones clínicas de urgencia	9
Conocimientos generales	7
Exámenes e imagenología	13
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	8

Situaciones clínicas

24 códigos

▶ VER CLASE **1.01.1.001** **Angina crónica estable**

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 2.1 · Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional

QUÉ HAY QUE SABER

- Angina típica: dolor opresivo retroesternal gatillado por esfuerzo o estrés, que cede con reposo o nitroglicerina sublingual en <10 min; patrón estable por semanas a meses.
- Confirmación: ECG de reposo (a menudo normal) y test de esfuerzo; alto riesgo si infradesnivel ST ≥2 mm, positivo en etapa 1 de Bruce o caída de la PAS. Si no puede caminar o ECG no interpretable: cintigrafía o eco de estrés.
- Terapia médica óptima: aspirina 100 mg/día + estatina de alta potencia (atorvastatina 40–80 mg, meta c-LDL <55 mg/dL) + betabloqueador (bisoprolol 5–10 mg, meta FC 55–60 lpm) + nitroglicerina SL 0,6 mg SOS.
- Segunda línea antianginosa: amlodipino 5–10 mg o nitratos de acción prolongada; IECA/ARA-II si HTA, DM, ERC o FEVI ≤40%. Control estricto de factores de riesgo y cese del tabaco.
- Derivar a cardiología para coronariografía si test de alto riesgo, angina refractaria a TMO o FEVI deprimida; cirugía (bypass) en tronco ≥50% o multivaso en diabéticos.
- Seguimiento completo en APS: síntomas (clase CCS), adherencia, PA, perfil lipídico y HbA1c; un cambio de patrón (reposo, mayor frecuencia) es angina inestable → urgencia.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 2.1

Hombre de 63 años con hipertensión y diabetes tipo 2 consulta por dolor torácico opresivo de 1 mes de evolución que aparece al subir dos pisos por escalera y desaparece a los 3 minutos de reposo. El ECG basal es normal. ¿Cuál es la prueba diagnóstica no invasiva de primera línea más adecuada para confirmar isquemia miocárdica y evaluar pronóstico en APS?

A Test de esfuerzo convencional en cinta rodante (Ergometría)

B Coronariografía invasiva inmediata sin pruebas previas

C Radiografía de tórax póstero-anterior y lateral

D Determinación seriada de troponinas en reposo

E Holter de ritmo cardíaco de 24 horas

Respuesta A. En un paciente con sospecha de angina crónica estable, capaz de realizar ejercicio físico y con un ECG basal normal e interpretable, la prueba no invasiva de primera elección recomendada por el MINSAL y consensos internacionales es el Test de Esfuerzo Convencional (Ergometría). Permite confirmar la presencia de isquemia miocárdica inducible, cuantificar el umbral isquémico en METs y estratificar el riesgo cardiovascular global.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 4

Un paciente con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes, usuario de aspirina, metformina, hidroclorotiazida y atorvastatina, presenta dolor torácico opresivo, que aparece al caminar 2 cuadras y alcanza un EVA de 5/10. Se solicita un test de esfuerzo que demuestra aparición de un infradesnivel del segmento ST, de 2 mm en las derivadas anteriores. El examen más adecuado para proseguir el estudio es:

A Ecocardiograma

B TAC de tórax

C Ecocardiografía de esfuerzo

D Coronariografía

E Cintigrafía de perfesión miocárdica

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Coronariografía). La angina estable con test de esfuerzo alterado, se estudia con coronariografía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 151

Paciente de 58 años, con antecedente de diabetes mellitus, hipertensión y fumador de 40 paquetes año, consulta por un cuadro de tres semanas de evolución de dolor epi- gástrico opresivo, asociado a disnea y palpitaciones regulares, que lo obligan a detener- se cada 100 metros de caminata y ceden con el reposo. En el examen físico, su presión arterial es 140/90 mmHg, frecuencia cardiaca de 80 latidos por minuto regular. El diag-

A Angina crónica de reciente comienzo

B Fibrilación auricular paroxística

C Isquemia cardiaca con arritmia supraventricular

D Tromboembolismo pulmonar

E Cardiopatía hipertensiva

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Angina crónica de reciente comienzo). La única opción aceptable era la angina de reciente comienzo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 2

Un paciente de 55 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y tabaquismo de 20 paquetes-año, consulta por dolor torácico de localización precordial y carácter opresivo. El cuadro inició hace tres semanas, presentándose el dolor en relación con la actividad física y desapareciendo rápidamente con el reposo. Sus signos vitales muestran presión arterial 148/92 mmHg, frecuencia cardíaca 81 latidos por minuto y saturación arterial de oxígeno de 96%. Su examen cardiopulmonar no muestra alteraciones. ¿Cuál es el examen de elección para precisar el diagnóstico?

A Coronariogra:a
B Cin2gra:a miocárdica
C Angiorresonancia de arterias coronarias
D Test de esfuerzo
E Electrocardiograma de 24 horas (Holter)

Respuesta D. Es una angina crónica estable. Su diagnóstico es clínico y su estudio comienza con una prueba de esfuerzo, generalmente el ECG de esfuerzo. En los casos en que no se puede realizar (amputados o pacientes que no toleran el ejercicio) y en los casos en que el electrocardiograma es ilegible (ej. BCRI), se utilizan otras pruebas de esfuerzo, como la ecocardiografía, con dobutamina o la cintigrafía cardiaca con talio y dipiridamol. Si alguna de estas pruebas de esfuerzo resulta alterada, se procede...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 82

Un paciente de 68 años, fumador y dislipidémico, en tratamiento con lavastatina y aspirina, comienza hace 2 meses con angina de pecho persistente, pero estable. ¿Qué fármaco es recomendable agregar?

A Amlodipino
B Dinitrato de isosorbide
C Carvedilol
D Enalapril
E Hidroclorotiazida

Respuesta B. Lo más importante en la angina crónica es revascularizar (se pide test de esfuerzo y luego angiografía, para hacer angioplastía o bypass) y, además, dejar las estatinas y sobre todo la aspirina. Sin embargo, además, sirven los nitritos, como el isosorbide o la nitroglicerina. Los demás son antihipertensivos o fármacos para la insuficiencia cardíaca.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 180

Un paciente de 65 años, hipertenso y diabético, consulta por disnea y dolor de precordial, que aparece en relación al ejercicio. Es usuario de aspirina, enalapril, metformina, glibenclamida y atorvastatina. Refiere que le es imposible subir más de dos pisos en su edificio o caminar más de dos cuadras sin detenerse, debido al dolor. Su examen físico es normal, al igual que su electrocardiograma. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Derivar a unidad de salud mental
B Solicitar test de esfuerzo
C Solicitar troponinas
D Indicar programa de ejercicios supervisados, con aumento progresivo
E Iniciar anticoagulación oral Nota: pregunta añadida a la reconstrucción.

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Solicitar test de esfuerzo (opción B).

▶ VER CLASE 1.01.1.002 Bloqueos aurículo-ventriculares

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 1.5 · Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)

QUÉ HAY QUE SABER

- BAV 1°: PR >200 ms constante, todas las P conducen; benigno, sin tratamiento. BAV 2° Mobitz I (Wenckebach): PR se alarga hasta una P bloqueada, nodal, suele ser benigno.
- BAV 2° Mobitz II: PR constante con P bloqueadas súbitas (infrahisiano, QRS a menudo ancho); BAV 3°: disociación AV completa con escape lento. Ambos tienen indicación de marcapaso definitivo (GES).
- Síntomas: mareo, síncope (Stokes-Adams), disnea, IC. Buscar causas reversibles: betabloqueador, calcioantagonista no DHP, digoxina, hiperkalemia, IAM inferior, enfermedad de Lyme/Chagas.
- Manejo inicial del bloqueo sintomático o inestable: atropina 1 mg EV (útil en nodales, inefectiva en infrahisianos); si falla, marcapaso transcutáneo o dopamina/adrenalina en infusión.
- Suspender fármacos frenadores y corregir electrolitos; ECG de 12 derivaciones y Holter si es intermitente.
- Seguimiento: derivar a cardiología para estudio e implante de marcapaso (Mobitz II y BAV completo, aunque sean asintomáticos).

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 1.5

Hombre de 76 años consulta por astenia y mareos de 3 días. El ECG revela ondas P a 70 lpm e intervalos PR de 160 ms constantes, pero cada tres ondas P, una no es seguida de complejo QRS sin que haya existido alargamiento previo del PR. El complejo QRS mide 130 ms. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta definitiva?

A Bloqueo AV de 2° grado Mobitz II; requiere implante de marcapaso definitivo

B Bloqueo AV de 2° grado Mobitz I; requiere observación ambulatoria

C Bloqueo AV de 1er grado; requiere suspender fármacos cronótropos

D Disociación auriculoventricular por intoxicación digitálica

E Paro sinusal con ritmo de escape de la unión

Respuesta A. El bloqueo intermitente de ondas P sin prolongación previa del intervalo PR define un Bloqueo AV de 2° Grado Mobitz II. Debido a que la lesión se encuentra en el sistema His-Purkinje infranodal, existe un alto riesgo de progresión a bloqueo completo y muerte súbita, por lo que tiene indicación formal de Marcapaso Definitivo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 21

Un paciente de 62 años presenta malestar general marcado, desde hace 20 minutos. Al examen físico está sudoroso, tiene FC: 33x', PA: 120/50 mmHg. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A Bloqueo auriculoventricular de primer grado

B Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo I

C Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo II

D Bloqueo auriculoventricular de tercer grado

E Enfermedad del nodo sinusal

Respuesta D. Se observa con disociación AV y, además, la FC cercana a 30 sugiere mucho un BAV completo o de tercer grado. Se deben saber identificar todas las arritmias de manera relativamente rápido en el EKG.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 138

Un paciente de 70 años presenta astenia, intolerancia al ejercicio y disnea de 3 meses de evolución. Además, presenta lipotimias luego de levantarse de la cama. Al examen físico tiene FC: 45 x', regular. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: cardioparamap.com): El diagnóstico más probable es:

A Bloqueo aurículo-ventricular de primer grado

B Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, Mobitz I

C Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, Mobitz II

D Bloqueo aurículo-ventricular completo

E Enfermedad del nodo sinusal

Respuesta D. Un paciente con bradicardia de 45 por minuto regular, síncope y mareos al levantarse, con ECG de disociación entre ondas P y complejos QRS, tiene un bloqueo auriculoventricular completo. El bloqueo de primer grado y el Mobitz I suelen ser asintomáticos, y la enfermedad del nodo sinusal muestra bradicardia sinusal con ondas P asociadas a cada QRS.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 163

¿Cuál es el diagnóstico que se visualiza en el siguiente electrocardiograma?

A Bloqueo AV completo

B Fibrilación auricular lenta

C Bloqueo AV de 2do grado

D Bradicardia sinusal

E Paro sinusal

Respuesta C. Tiene una imagen de un BAV de segundo grado, Mobitz I, en que se va alargando el PR, hasta que una onda P no conduce.

▶ VER CLASE 1.01.1.003 Cardiopatía congénita en adulto

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 4.4 · Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante soplo, cianosis, hipertensión pulmonar, arritmias auriculares o embolía paradójica en un adulto joven; muchas se descubren por ECG o radiografía alterados.
- CIA (la más frecuente diagnosticada en adultos): desdoblamiento amplio y fijo del S2, soplo sistólico pulmonar, BCRD en ECG y crecimiento de cavidades derechas.
- CIV: soplo holosistólico rudo paraesternal izquierdo con frémito. Ductus: soplo continuo en maquinaria. Coartación: HTA en brazos, pulsos femorales débiles y muescas costales (Roesler).
- Síndrome de Eisenmenger: inversión del shunt (D→I) con cianosis e hipocratismo; el cierre del defecto está contraindicado y el embarazo es de muy alto riesgo.
- Manejo inicial: ecocardiograma, tratar IC o arritmias, profilaxis de endocarditis en cardiopatías cianóticas o reparadas con material protésico, consejo preconcepcional.
- Seguimiento: derivar a cardiología (centro de cardiopatías congénitas del adulto) para definir cierre percutáneo o quirúrgico y control de por vida.

PREGUNTAS · 12

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 3

Un paciente de 28 años, con antecedente de haber sido operado de coartación aórtica cuando niño, consulta por un cuadro progresivo de disnea de esfuerzos y ortopnea, que ha deteriorado significativamente su capacidad funcional. En el examen físico tiene pulso palpable con frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, presión arterial de 155/75 mmHg y frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, saturando 92% a FiO2 ambiental. Al examen cardiopulmonar, tiene ritmo regular en dos tonos, con soplo sistólico eyectivo II/VI en la zona paraesternal, más un soplo diastólico, que se escucha hasta la final de la diástole en el mismo foco. Su padre falleció a los 50 años, de manera súbita. ¿Cuál es el diagnóstico más importante?

A Recoartación aórtica
B Estenosis aórtica
C Insuficiencia aórtica
D Insuficiencia tricuspídea
E Disección aórtica

Respuesta A. Diagnóstico: Recoartación aórtica (opción A). El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 147

Mujer de 45 años que recuerda que durante un embarazo hace 20 años le diagnosticaron un soplo cardíaco. Actualmente asintomática, tolera el ejercicio normal. Auscultación: soplo sistólico II/VI en foco pulmonar con desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Tetralogía de Fallot
B Ductus arterioso persistente
C Estenosis pulmonar
D Comunicación interauricular (CIA)
E Comunicación interventricular

Respuesta D. CIA: soplo sistólico de eyección en foco pulmonar (por hiperflujo pulmonar) + desdoblamiento FIJO del S2 (por sobrecarga de volumen en VD independiente de la respiración) = signo casi patognomónico de CIA. Suele diagnosticarse en embarazo por el aumento del gasto cardíaco.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 28

Un hombre de 40 años consulta por disnea de esfuerzos de algunos años de evolución, que aparece con medianos esfuerzos, asociada a palpitaciones ocasionales. Al examen físico tiene edema de extremidades inferiores, FC: 75x', PA: 120/80 mmHg, murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos bibasales y al examen cardíaco presenta un soplo sistólico de ubicación paraesternal, con segundo ruido desdoblado fijo. Se solicita un electrocardiograma, que muestra eje a +120°, fibrilación auricular, con un bloqueo completo de la rama derecha del haz de His. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Comunicación interauricular
B Ductus arteriosos persistente
C Comunicación interventricular
D Estenosis aórtica
E Estenosis mitral

Respuesta A. Diagnóstico: Comunicación interauricular (opción A). Es una CIA clásica, por la dilatación derecha y el desdoblamiento fijo del 2º ruido. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 32

Pregunta 32 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente de 40 años, consulta por un cuadro, de algunos meses de evolución, de disnea de esfuerzos, progresiva, asociada a ortopnea y edema de extremidades inferiores. Al examen físico se auscultan crepitaciones pulmonares bilaterales, con un soplo en la zona paraesternal izquierda, en el segundo espacio intercostal. Su radiografía muestra signos de hiperflujo pulmonar, con botón pulmonar prominente. Su electrocardiograma muestra un patrón rSr. El diagnóstico más probable es:

A Comunicación interauricular
B Dustus arterioso persistente
C Estenosis aórtica
D Comunicación interventricular
E Insuficiencia aórtica

Respuesta A. Diagnóstico: Comunicación interauricular (opción A). Era una clásica CIA del adulto, con toda su clínica, excepto el desdoblamiento fijo del R2. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 86

Un hombre de 40 años consulta por disnea y palpitaciones ocasionales. Al examen físico presenta un soplo sistólico basal, con desdoblamiento fijo del segundo ruido. Se solicita un electrocardiograma, que muestra un bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Comunicación interauricular
B Ductus arteriosos persistente
C Comunicación interventricular
D Estenosis aórtica
E Estenosis pulmonar

Respuesta A. Es una CIA (comunicación interauricular) clásica, aunque en un adulto: soplo sistólico eyectivo, desdoblamiento del segundo ruido y eje desviado a derecha.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 57

Un paciente de 30 años presneta un cuadro de astenia, adinamia y disnea de esfuerzos. Presenta un soplo sistólico eyectivo, con desdoblamiento del segundo ruido y algunos crépitos pulmonares. Su electrocardiograma muestra un bloqueo completo de rama derecha. El diagnóstico más probable es:

A Comunicación interventricular
B Comunicación interauricular
C Ductus arterioso persistente
D Tetralogía de Fallot
E Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

Respuesta B. Diagnóstico: Comunicación interauricular (opción B). Cuadro clásico. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 113

Un paciente de 18 años, asintomático, acude a control médico, para evaluación para realizar deporte. Se encuentra asintomática y en su examen físico se pesquisa la presencia de un soplo sistólico de intensidad III/VI en la zona paraesternal izquierda. Su electrocardiograma es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Comunicación interauricular
B Estenosis aórtica
C Comunicación interventricular
D Estenosis pulmonar
E Ductus arterioso persistente

Respuesta A. Por clínica, parece un soplo funcional. Sin embargo, no está entre las opciones. Por estar en el foco pulmonar (paraesternal izquierdo), se debe marcar CIA. La estenosis aórtica sopla paraesternal derecho (foco aórtico). La CIV tiene soplo holosistólico y el ductus tiene soplo continuo. La estenosis pulmonar tendría otros síntomas y es mucho menos frecuente que la CIA.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 137

Un paciente de 24 años presenta disnea de esfuerzos, asociado a edema de extremidades inferiores. Refiere antecedente de soplo en la infancia. Al examen físico tiene PA: 120/80 mmHg, FC: 74x', examen cardiopulmona con un segundo ruido desdoblado y fijo, un soplo sistólico eyectivo, paraesternal izquierdo y crepitaciones escasas en ambas bases pulmonares. El electrocardiograma muestra una imagen de bloqueo completo de rama derecha. El diagnóstico más probable es:

A Comunicación interauricular
B Comunicación interventricular
C Coartación aórtica
D Ductus arterioso persistente
E Tetralogía de Fallot

Respuesta A. Diagnóstico: Comunicación interauricular (opción A). Es una CIA clásica. Insisto, de verdad hay que aprenderse el resumen de semiología cardíaca. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 24

Una paciente de 27 años, con antecedente de soplo en la infancia, consulta por aste- nia y disnea que aparece con medianos esfuerzos. Al examen físico presenta edema de extremidades inferiores, ritmo regular en dos tiempos con soplo sistólico intenso aso- ciado a segundo ruido desdoblado permanente, murmullo pulmonar disminuido en ba- ses con crépitos bilaterales. Su electrocardiograma muestra arritmia completa por fibri- lación auricular y bloqueo completa de la rama de His.

A Comunicación interventricular
B Comunicación interauricular
C Estenosis mitral
D Estenosis aórtica
E Conducto arterioso persistente

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Comunicación interauricular). Es una CIA clásica. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 148

Adulto con disnea de esfuerzos, crepitaciones pulmonares, soplo sistólico con desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Diagnóstico más probable?

A Comunicación interauricular

B Estenosis pulmonar moderada

C Comunicación interventricular pequeña

D Insuficiencia tricuspídea

E Bloqueo de rama derecha sin cardiopatía

Respuesta A. Diagnóstico: Comunicación interauricular (opción A). Comunicación interauricular. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 68

Sd de down q se cansaba al mamar con soplo continuo con pulso saltón:

A DAP

B Canal AV - cuál era esta??? DAP porque el soplo era continuo, sin embargo, canal AV es la primera valvulopatía en sd down y se preguntó en pruebas anteriores : (

C Comunicación Inter ventricular

D Ninguna de las anteriores es correcta

E Todas las anteriores son correctas

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (DAP). El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 28 años, asintomática, consulta por soplo detectado en examen preocupacional. Al examen: soplo sistólico eyectivo 2/6 en foco pulmonar y desdoblamiento amplio del segundo ruido que no varía con la respiración. ECG: ritmo sinusal con bloqueo completo de rama derecha. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Comunicación interauricular

B Estenosis aórtica bicúspide

C Comunicación interventricular

D Ductus arterioso persistente

E Coartación aórtica

Respuesta A. El desdoblamiento amplio y fijo del S2 con BCRD y soplo pulmonar por hiperflujo es característico de la CIA, la cardiopatía congénita más frecuentemente diagnosticada en adultos. Se confirma con ecocardiograma y se deriva a cardiología.

▶ VER CLASE 1.01.1.004 Corazón pulmonar crónico

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 1.5 · Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)

QUÉ HAY QUE SABER

- Corazón pulmonar crónico: hipertrofia/dilatación del VD secundaria a hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar (EPOC la causa más frecuente), hipoxemia crónica, SAHOS o TEP crónico.
- Clínica: disnea de esfuerzo, ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva, edema de EEII, R2 pulmonar aumentado y soplo de insuficiencia tricuspídea.
- Confirmación: ECG con P pulmonar (>2,5 mm en DII), eje derecho y signos de HVD; Rx con arterias pulmonares prominentes; ecocardiograma estima PSAP y función del VD.
- Tratamiento inicial: tratar la enfermedad pulmonar de base, oxigenoterapia crónica si PaO2 ≤55 mmHg o SatO2 ≤88% (o ≤59 mmHg con poliglobulia/cor pulmonale) ≥15 h/día, diuréticos con cautela.
- Evitar betabloqueadores no selectivos y sedantes; vacunación antiinfluenza y antineumocócica; descartar TEP crónico ante hipertensión pulmonar desproporcionada.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar/cardiología para estudio de hipertensión pulmonar y manejo especializado.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 115

Un paciente de 76 años, fumador de 80 paquetes-año, con EPOC severo en tratamiento con budesonida y salmeterol inhalados, presenta aumento de su disnea e intolerancia al ejercicio desde hace 7 días, asociado a edema de extremidades inferiores. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca 100 por minuto, presión arterial 110/70 mmHg e ingurgitación yugular a 45°. Se ausculta ritmo regular en dos tonos con ruidos apagados y murmullo pulmonar disminuido de manera bilateral, con roncus y sibilancias difusos. Se solicita ecocardiograma que muestra cavidades izquierdas con leve dilatación del ventrículo izquierdo y fracción de eyección conservada de 58%, y cavidades derechas dilatadas con paredes hipertróficas, con estimación de presión de arteria pulmonar de 68 mmHg. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hipertensión pulmonar primaria
B Insuficiencia cardíaca congestiva
C Exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica
D Cor pulmonale descompensado
E Tromboembolismo pulmonar

Respuesta D. Signos de insuficiencia cardíaca derecha (edema, ingurgitación yugular) con cavidades derechas dilatadas e hipertróficas e hipertensión pulmonar secundaria a EPOC: cor pulmonale. La función izquierda está conservada. En EPOC, el cor pulmonale es criterio de oxígeno domiciliario con PaO2 56–59 mmHg.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 58

Un paciente de 62 años, fumador de 30 paquetes años, presenta edema de extremidades inferiores, asociado a astenia, disnea y adinamia. Al examen físico presenta yugulares visibles a 45 grados y aumento de la intensidad del segundo ruido cardiaco. Su electrocardiograma muestra una onda R prominente en V1 más un bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Estenosis tricuspidea
B Pericarditis constrictiva
C Cardiopatía coronaria
D Cor pulmonale
E Cardiopatía hipertensiva

Respuesta D. Diagnóstico: Cor pulmonale (opción D). Cuadro clásico (insuficiencia cardiaca derecha, por HTP, por enfermedad pulmonar (EPOC).

▶ VER CLASE 1.01.1.005 Dislipidemias

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.4 · Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico con perfil lipídico (ayuno 9–12 h si TG altos): c-LDL elevado es el principal blanco; hipertrigliceridemia ≥150 mg/dL; HDL bajo <40 mg/dL en hombres y <50 en mujeres. Descartar causas secundarias (hipotiroidismo, DM, síndrome nefrótico, colestasia, fármacos).
- Estratificar riesgo cardiovascular (tablas chilenas Framingham adaptadas): prevención secundaria, DM, ERC o LDL ≥190 mg/dL son de alto riesgo por definición.
- Metas c-LDL: <70 mg/dL en alto riesgo (<55 en muy alto riesgo/prevención secundaria), <100 en riesgo moderado, <130 en bajo riesgo.
- Tratamiento: cambios de estilo de vida + estatina (atorvastatina 10–80 mg o rosuvastatina 5–40 mg según intensidad necesaria); si no se logra meta, agregar ezetimiba 10 mg.
- TG ≥500 mg/dL: fibrato (gemfibrozilo/fenofibrato) para prevenir pancreatitis, restricción de alcohol y azúcares; no combinar gemfibrozilo con estatina (miopatía).
- Seguimiento: perfil lipídico y transaminasas a las 6–12 semanas de iniciar o ajustar, luego anual; CK solo si mialgias. Programa de Salud Cardiovascular en APS.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 157

Un paciente de 66 años, diabético e hipertenso, con antecedente de un infarto agudo al miocardio, hace 1 año, se realiza perfil lipídico, que muestra triglicéridos: 325 mg/dl, colesterol LDL: 125 mg/dl, colesterol HDL: 30, colesterol total: 220 mg/dl. **¿Cuál es el tratamiento de elección para el manejo de su dislipidemia?**

A Atorvastatina 40 mg/día
B Fenofibrato 160 mg/día
C Gemfibrozilo 600 mg cada 12 horas
D Aporte de ácidos grasos omega 3
E Rosuvastatina 10 mg/día

Respuesta A. Infarto previo: riesgo cardiovascular muy alto, meta de c-LDL bajo 55–70 mg/dL. Con triglicéridos bajo 500 mg/dL la prioridad es el LDL, y se indica una estatina de alta intensidad: atorvastatina 40 mg. Rosuvastatina 10 mg es de intensidad moderada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 139

Un paciente de 68 años con diagnóstico reciente de ateromatosis aórtica y carotídea se realiza un perfil lipídico que muestra: colesterol total: 194 mg/dL, colesterol LDL: 93 mg/dL, HDL: 37 mg/dL y triglicéridos: 287 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?**

A Iniciar metformina

B Iniciar gemfibrozilo

C Iniciar atorvastatina

D Iniciar ácido nicotínico

E Iniciar ezetimibe

Respuesta C. La ateromatosis aórtica y carotídea es enfermedad ateroesclerótica documentada: el riesgo es alto o muy alto y la meta de c-LDL es menor de 70 mg/dL. Un LDL de 93 no está en meta. Con triglicéridos bajo 500 mg/dL la prioridad es el LDL: estatina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 108

Un paciente diabético, hipertenso y con antecedente de una cardiopatía coronaria, en tratamiento con aspirina, metformina, glibenclamida y enalapril, se realiza un perfil lipídico, que se informa como LDL: 165 mg/dl, HDL: 38 mg/dl, triglicéridos: 288 mg/dl. Inició atorvastatina 40 mg al día, las que suspendió por presentar artralgias y mialgias. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar rosuvastatina 10 mg y controlar con CK

B Iniciar fenofibrato mg y controlar con perfil lipídico y glicemia

C Iniciar atorvastatina 5 mg cada 2 días

D Iniciar ezetimibe

E Reforzar la dieta

Respuesta A. Coronario: necesita estatina. Ante síntomas musculares, se reintroduce con otra estatina más hidrofílica y a dosis menor (rosuvastatina), controlando con CK para descartar miopatía. Abandonar la estatina deja al paciente sin su principal protección.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 53

Un paciente hipertenso y diabético se realiza un perfil lipídico, que muestra triglicéridos de 350 mg/dL, colesterol LDL de 230 mg/dL y colesterol HDL de 37 mg/dL. **¿Qué tratamiento debe indicarse?**

A Atorvastatina

B Gemfibrozilo

C Insulina

D Lovastatina más gemfibrozilo

E Ezetimibe

Respuesta A. En un diabético hipertenso, de alto riesgo, el objetivo primario es el LDL; con triglicéridos bajo 500 mg/dL no se prioriza el fibrato. Corresponde una estatina potente como atorvastatina. La combinación de estatina con gemfibrozilo aumenta el riesgo de miopatía y rabdomiólisis.

▶ VER CLASE 1.01.1.006 **Embolia pulmonar** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Cardiología 5.5 · Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP)
Traumatología 12.3 · Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar TEP ante disnea súbita, dolor pleurítico, taquicardia, hemoptisis o síncope, sobre todo con factores de riesgo: TVP, cirugía o inmovilización reciente, cáncer, embarazo, ACO.
- Probabilidad clínica con score de Wells: baja/intermedia → dímero D (negativo descarta); alta → angioTAC de tórax directo. ECG: taquicardia sinusal, S1Q3T3 o BCRD.
- TEP con inestabilidad (PAS <90 mmHg): soporte, O2 y trombolisis sistémica con alteplasa 100 mg EV en 2 h si no hay contraindicación.
- TEP estable: anticoagular de inmediato si la sospecha es alta, sin esperar imagen: enoxaparina 1 mg/kg c/12 h SC o heparina no fraccionada; luego DOAC o acenocumarol por al menos 3 meses.
- Estratificar con sPESI, troponina y función del VD; tromboprofilaxis en pacientes hospitalizados de riesgo es la principal medida preventiva.
- Seguimiento: derivar a especialista (medicina interna/broncopulmonar) para definir duración de anticoagulación y estudio de trombofilia o cáncer según el caso.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente con fractura de fémur tratada hace tres días presenta en forma súbita disnea intensa y desaturación. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen de elección?**

A Embolia grasa; dímero D

B Tromboembolismo pulmonar; angiotac de tórax

C Tromboembolismo pulmonar; dímero D

D Síndrome compartimental; fasciotomía inmediata

E Neumonía aspirativa; radiografía de tórax

Respuesta B. El TEP aparece días después de una fractura, con disnea o dolor torácico súbito, y el examen de elección es el angiotac de tórax. El dímero D no es útil porque la fractura ya lo eleva. La embolia grasa aparece en las primeras horas, con tríada de distrés, compromiso de conciencia y petequias.

▶ VER CLASE 1.01.1.007 Endocarditis infecciosa y no infecciosa

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 4.5 · Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar endocarditis infecciosa ante fiebre + soplo nuevo o cambiante, especialmente en valvulopatía, prótesis valvular, usuario de drogas EV, catéteres o hemodiálisis.
- Signos: petequias, hemorragias en astilla, nódulos de Osler (dolorosos), lesiones de Janeway, manchas de Roth, esplenomegalia, embolías (ACV, renal, esplénica) y glomerulonefritis.
- Criterios de Duke: mayores = hemocultivos positivos para germen típico (S. aureus, estreptococos viridans, enterococo, HACEK) y ecocardiograma con vegetación, absceso o dehiscencia protésica.
- Manejo inicial: 3 pares de hemocultivos ANTES de antibióticos, ecocardiograma (transesofágico si prótesis o eco transtorácico negativo) e inicio de antibiótico empírico EV tras los cultivos.
- Endocarditis no infecciosa (marántica en cáncer, Libman-Sacks en LES): vegetaciones estériles con riesgo embólico; tratar enfermedad de base y anticoagular según el caso.
- Seguimiento: derivar para hospitalización y manejo por cardiología/infectología (cirugía si IC, absceso o embolías recurrentes). Profilaxis con amoxicilina 2 g antes de procedimientos dentales solo en alto riesgo.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 63

Un paciente de 57 años consulta por un cuadro de 7 días de astenia, malestar general y fiebre hasta 39 °C. Al examen físico tiene un soplo pansistólico III/VI en el precordio izquierdo, además de petequias en los pulpejos y algunas petequias subconjuntivales. **¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico etiológico?**

A Ecocardiograma

B Hemocultivos

C Hemograma

D Coronariografía

E ANA y complemento

Respuesta B. Fiebre, soplo y fenómenos embólicos sugieren endocarditis infecciosa. El diagnóstico etiológico, es decir el germen, lo dan los hemocultivos seriados (3 sets antes de antibióticos). El ecocardiograma muestra vegetaciones y es criterio mayor, pero no identifica el agente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 70

Un paciente de 45 años, consulta por fiebre de 3 semanas de evolución sin otros sín- tomas. Al examen físico tiene temeratura 37,8°C, frecuencia cardiaca de 92 por minuto, con presión arterial 120/80mmHG. Al examen cardiaco se ausulta un soplo sistólico en ápex irradiado a dorso. En sus exámenes destacan leucocitos de 12.000/mm3 y PCR 9,6 (valor normal menor a 1,0). ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?

A Ecocardiografía bidimensional

B Resonancia magnética cardiaca

C Radiografía de tórax

D AngioTAC de tórax

E TAC de tórax abdomen y pelvis

Respuesta A. Se sospecha un endocarditis bacteriana subaguda (mayor a 7 días), por lo que se debe pedir hemocultivos y ecocardiografía.

▶ VER CLASE 1.01.1.008 Enfermedad reumática activa

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.13 · Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

QUÉ HAY QUE SABER

- Fiebre reumática: 2–4 semanas tras faringoamigdalitis estreptocócica no tratada, típicamente 5–15 años. Diagnóstico por criterios de Jones + evidencia de infección estreptocócica (ASO elevada, cultivo o test rápido).

- Criterios mayores: carditis, poliartritis migratoria de grandes articulaciones, corea de Sydenham, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Menores: fiebre, artralgias, VHS/PCR elevadas, PR prolongado.
- Diagnóstico: 2 mayores o 1 mayor + 2 menores, más evidencia de infección estreptocócica previa; ecocardiograma a todos para detectar carditis.
- Tratamiento: erradicar el estreptococo con penicilina benzatina 1.200.000 UI IM (600.000 UI si <27 kg); aspirina en dosis antiinflamatorias para la artritis; corticoides en carditis moderada-severa; reposo.
- Profilaxis secundaria con penicilina benzatina c/21–28 días: sin carditis 5 años o hasta los 21 años; carditis sin secuela 10 años o hasta los 21; con secuela valvular 10 años o hasta los 40 (o de por vida).
- Seguimiento: control clínico y ecocardiográfico periódico por secuelas valvulares (mitral la más afectada) y adherencia estricta a la profilaxis.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 9 años consulta por dolor e inflamación de la rodilla derecha que luego migra al codo izquierdo y al tobillo, de 5 días de evolución, con fiebre de 38,5 °C. Hace 3 semanas tuvo odinofagia febril que no fue tratada. Al examen se ausculta un soplo holosistólico apical leve, nuevo. La VHS es 80 mm/h y la ASO está elevada. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Amoxicilina por 7 días y paracetamol

B Reposo y AINE por 5 días, sin seguimiento

C Prednisona sola por 2 semanas, sin antibióticos

D Ceftriaxona endovenosa por 4 semanas

E Penicilina benzatina, ácido acetilsalicílico en dosis antiinflamatorias y luego profilaxis secundaria con penicilina benzatina

Respuesta E. Cumple criterios de Jones: poliartritis migratoria y carditis (mayores), fiebre y VHS alta (menores), con infección estreptocócica previa (ASO). Se erradica el estreptococo con penicilina benzatina, se trata la inflamación y se indica profilaxis secundaria prolongada, porque las recurrencias agravan la valvulopatía.

▶ VER CLASE **1.01.1.009** **Estenosis aórtica** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 4.1 · Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad & TAVI vs SAVR (Guía GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Estenosis aórtica: causa degenerativa-calcificada en >65 años, bicúspide en menores. Tríada de síntomas: angina, síncope de esfuerzo y disnea/IC; su aparición marca mal pronóstico.
- Examen: soplo mesosistólico eyectivo en foco aórtico irradiado a carótidas, pulso parvus et tardus, S2 apagado o único, choque de punta sostenido.
- Confirmación con ecocardiograma: severa si área valvular <1,0 cm², gradiente medio ≥40 mmHg o velocidad pico ≥4 m/s. ECG con HVI.
- Manejo inicial: tratar IC con diuréticos con cautela; evitar vasodilatadores potentes (nitratos) y depleción de volumen por riesgo de hipotensión. Prohibido el ejercicio intenso si es severa.
- Toda estenosis aórtica severa sintomática tiene indicación de reemplazo valvular (quirúrgico o TAVI), con garantía GES para tratamiento quirúrgico de valvulopatías.
- Seguimiento: derivar a cardiología; ecocardiograma seriado según severidad (anual si severa asintomática).

PREGUNTAS · 9

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 4.1

Hombre de 76 años consulta por disnea de esfuerzos progresiva y mareos. Al examen físico destaca un pulso carotídeo de baja amplitud y ascenso lento (parvus et tardus) y un soplo mesosistólico en foco aórtico irradiado a carótidas. Ecocardiograma: área valvular aórtica de 0.8 cm² y gradiente medio de 45 mmHg con FEVI de 55%. ¿Cuál es la conducta médica definitiva más adecuada?

A Reemplazo valvular aórtico percutáneo (TAVI) o quirúrgico

B Tratamiento médico exclusivo con Betabloqueadores y control anual

C Iniciar Enalapril y Nitratos en dosis crecientes

D Valvuloplastía aórtica con balón como tratamiento curativo definitivo

E Test de esfuerzo convencional para medir capacidad funcional

Respuesta A. El paciente tiene una Estenosis Aórtica Severa Sintomática (AVA 40 mmHg). La aparición de síntomas es una indicación formal de reemplazo valvular (TAVI en ancianos o cirugía en jóvenes) para evitar la muerte súbita y mejorar el pronóstico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 126

Un paciente de 80 años presenta disnea de esfuerzo de algunos meses de evolución, progresiva. Hace 24 horas sufre un síncope, con recuperación completa. Al examen físico tiene FC: 75x', PA: 110/70 mmHg se palpa el choque de la punta en el 4° espacio intercostal, línea medio clavicular y se ausculta el corazón con presencia de soplo protomesosistólico III/VI y segundo ruido muy apagado. El examen pulmonar no muestra alteraciones. Se solicita un electrocardiograma, que muestra un ritmo sinusal con onda S de 23 mm en V2 y onda R de 16 mm en V5. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Estenosis aórtica

B Estenosis mitral

C Insuficiencia aórtica

D Insuficiencia mitral

E Cardiopatía coronaria

Respuesta A. Es una estenosis aórtica clásica. De verdad hay que leer y aprenderse el resumen de semiología cardíaca.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 174

Una paciente de 41 años presenta disnea de grandes esfuerzos de larga data, a lo que en el último tiempo se ha agregado opresión precordial en relación a la actividad física, que cede con el reposo. Tiene antecedente de un soplo en la infancia no estudiado. En el examen físico presenta frecuencia cardíaca: 68 por minuto, presión arterial: 120/85 mmHg, pulso regular de ascenso lento y baja amplitud en ambas extremidades superiores, y se ausculta un ritmo cardíaco regular en dos tiempos con presencia de un soplo sistólico en foco aórtico III/VI y un soplo diastólico en el mismo foco II/VI. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Estenosis mitral
B Estenosis aór2ca
C Insuficiencia mitral
D Insuficiencia aór2ca
E Comunicación interauricular

Respuesta B. Tiene una estenosis aórtica clásica (revisar resumen de semiología cardíaca), caracterizada por soplo sistólico eyectivo (foco aórtico), pulso parvus et tardus, síncopes, angina de pecho y arritmias. Aunque la presión está normal en este caso, lo clásico es que la presión de pulso (distólica - diastólica) esté disminuida, haciendo que el pulso se palpe débil (parvus = pequeño). El soplo diastólico concomitante, probablemente se deba a que Gene algún grado de insuficiencia aórtica asociada,...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 168

Un paciente de 80 años, hipertenso en tratamiento hace 10 años, consulta por disnea de esfuerzos, que inició hace 6 meses. Al examen físico destaca PA 150/90, ritmo regular, con ausencia del segundo ruido, asociado a soplo mesosistólico III/VI en margen esternal izquierdo, pulso carotídeo de ascenso lento y choque punta en el quinto espacio intercostal izquierdo. El diagnóstico más probable es:

A Estenosis mitral
B Estenosis aórtica
C Insuficiencia aórtica
D Insuficiencia mitral
E Miocardiopatía dilatada

Respuesta B. Es una estenosis aórtica de libro. En el manual de semiología cardíaca veremos las clínicas de todas las patologías cardíacas, ya que siempre se preguntan.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 56

Un paciente de 79 años presenta dolor torácico opresivo, que aparece al caminar y que cede con el reposo. Al examen físico se ausculta un soplo sistólico IV de VI, irradiado a la zona baja del cuello. El examen más adecuado para proseguir con su estudio es:

A Prueba de esfuerzo
B Electrocardiograma
C Coronariografía
D AngioTAC de torax
E Ecocardiografía doppler

Respuesta E. Pregunta difícil. Parece una angina estable, pero en realidad es una estenosis aórtica (por el soplo) y por tanto se debe pedir ecocardio primero

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 101

Un paciente de 20 años, con antecedente de soplo en su infancia, consulta por sensación de opresión precordial, que aparece al caminar, se asocia a disnea leve y que cede rápidamente con el reposo. Al examen físico tiene PA: 150/80 mmHg, FC: 63x', pulso débil, regular, de ascenso lento. El examen cardíaco muestra un soplo sistólico eyectivo, paraesternal, que se irradia al cuello. Su electrocardiograma muestra signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. El diagnóstico más probable es:

A Estenosis mitral
B Estenosis aórtica
C Insuficiencia mitral
D Insuficiencia aórtica
E Miocardiopatía hipertrófica

Respuesta B. Es una estenosis aórtica clásica, probablemente congénita. Deben revisar el resumen de semiología cardíaca completo y aprendérselo hoy de una vez por todas. Insisto: hoy. El pulso débil y de ascenso lento (parvus et tardus) hace que sea una estenosis aórtica y no una MCPHT, que tiene pulso amplio o Celler.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 110

Adulto mayor de 81 años, consulta por pérdida de conciencia súbita con recupera- ción ad integrum. Al examen físico, presión arterial de 140/90 mmHg, con frecuencia cardiaca de 75 latidos por minuto, soplo sistólico eyectivo irradiado al cuello y choque de la punta se palpa en el quinto espacio intercostal. El diagnóstico más probable es:

A Estenosis aórtica
B Miocardiopatía dilatada
C Miocardiopatía hipertrófica
D Enfermedad coronaria con afectación del sistema excito-conductor
E Tromboembolismo pulmonar

Respuesta A. Diagnóstico: Estenosis aórtica (opción A). Tiene el soplo clásico, más los síncopes de la estenosis aórtica. Además la edad orienta mucho.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 55

Un paciente de 82 años ha presentado disnea de esfuerzos y ha presentado síncope, relacionado con actividad física, con recuperación total. Al examen físico presenta presión arterial 120/70 mmHg, FC: 70 x', y a la auscultación cardiaca tiene un soplo paraesternal, de tonalidad ruda, luego del primer ruido, asociada a una disminución marcada del segundo ruido. Además, el choque de la punta se palpa desplazado. El diagnóstico más probable es:

A Estenosis aórtica
B Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
C Estenosis mitral
D Insuficiencia mitral
E Cardiopatía coronaria

Respuesta A. Es estenosis aórtica por el síncope y el soplo. Eso sí, la cardiomegalia (desplazamiento del choque de la punta) aparece en estadíos muy avanzados.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 131

Valvulopatía en paciente joven con síncope a. Estenosis aórtica

A Ninguna de las anteriores es correcta
B Todas las anteriores son correctas
C No se dispone de información suficiente
D Otra alternativa no descrita
E Otra alternativa no descrita

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Ninguna de las anteriores es correcta).

▶ VER CLASE 1.01.1.010 **Estenosis mitral** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 4.2 · Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática

QUÉ HAY QUE SABER

- Estenosis mitral: secuela de fiebre reumática en >90%; más frecuente en mujeres. Síntomas: disnea, ortopnea, hemoptisis, palpitaciones por FA y embolías sistémicas.
- Examen: R1 brillante, chasquido de apertura y rodada (retumbo) diastólica apical con refuerzo presistólico; facies mitral. Embarazo y FA precipitan descompensación.
- Confirmación con ecocardiograma: severa si área valvular <1,5 cm². ECG con P mitral (bífida) o FA; Rx con crecimiento de AI (doble contorno).
- Manejo inicial: betabloqueador para control de frecuencia (prolonga el llenado diastólico), diuréticos si congestión.
- Estenosis mitral con FA, embolía previa o trombo auricular: anticoagulación con antagonista de vitamina K (meta INR 2–3); los DOAC están contraindicados.
- Seguimiento: derivar a cardiología; valvuloplastía percutánea con balón si la anatomía es favorable (score de Wilkins ≤8) o cirugía valvular (GES).

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 4.2

¿Cuál es el tratamiento de elección para una paciente joven sintomática con estenosis mitral reumática severa (área 1.1 cm²), valvas móviles sin calcificación y Score de Wilkins de 6 puntos?

A Valvuloplastía mitral percutánea con balón
B Reemplazo valvular mitral con prótesis mecánica
C Comisurotomía quirúrgica a cielo abierto
D Tratamiento exclusivo con Furosemida oral
E Cierre percutáneo de la orejuela izquierda

Respuesta A. En la estenosis mitral severa con anatomía valvular favorable definida por un Score de Wilkins ≤ 8 puntos (valvas móviles, poco engrosadas y sin calcificación comisural severa ni insuficiencia mitral significativa), la Valvuloplastía Mitral Percutánea con Balón es el tratamiento de primera elección por su alta eficacia y mínima invasividad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 128

Un paciente de 70 años consulta por disnea de medianos esfuerzos progresiva, asociada a ortopnea. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca: 78 lpm, presión arterial: 130/80 mmHg, examen pulmonar con murmullo vesicular conservado y presencia de crépitos bibasales, examen cardíaco con ritmo irregular en dos tiempos, con presencia de soplo diastólico. Se palpa el choque de la punta en el quinto espacio intercostal línea medioclavicular y se observa edema en extremidades inferiores con signo de la fóvea. Su electrocardiograma muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Estenosis aórtica
B Estenosis pulmonar
C Estenosis mitral
D Insuficiencia aórtica
E Insuficiencia pulmonar

Respuesta C. Estenosis Mitral: El cuadro clínico es compatible con estenosis mitral. Se recomienda repasar la semiología cardíaca.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 158

Un paciente de 58 años presenta disnea de medianos esfuerzos y astenia. Al examen físico tiene FC: 70 lpm, PA: 120/80 mmHg, examen cardíaco con choque de la punta en el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular y auscultación con un soplo diastólico. Al examen pulmonar se constata murmullo pulmonar presente, con crepitaciones basales escasas. Su electrocardiograma muestra fibrilación auricular, con respuesta ventricular de 70 latidos por minuto. El diagnóstico más probable es:

A Estenosis aórtica
B Insuficiencia aórtica
C Estenosis tricuspídea
D Estenosis mitral
E Comunicación interventricular

Respuesta D. Tiene una estenosis mitral clásica (soplo diastólico, se asocia a FA y tiene VI de tamaño normal, con crecimiento de la AI). Ver resumen de semiología cardíaca.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 80

Una paciente de 58 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril, consulta por disnea de esfuerzo que ha empeorado en el último tiempo

A Estenosis mitral
B Estenosis aórtica
C Miocardiopatía hipertrófica
D Insuficiencia aórtica
E Cardiopatía hipertensiva

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Estenosis mitral (opción A). Es una estenosis mitral clásica, con FA y todo.

▶ VER CLASE 1.01.1.011 Extrasistolía ventricular benigna

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 1.6 · Extrasístoles Ventriculares Benignas y Holter de Ritmo

QUÉ HAY QUE SABER

- Extrasístoles ventriculares: QRS ancho (>120 ms) prematuro, sin onda P previa y con pausa compensatoria completa; muy frecuentes en sanos, a menudo asintomáticas o con palpitaciones ('saltos').
- Benignas si: corazón estructuralmente sano, monomorfas, desaparecen con el ejercicio y sin historia familiar de muerte súbita.
- Estudio: ECG, Holter de 24 h (cuantificar carga), ecocardiograma para descartar cardiopatía; electrolitos (K, Mg) y TSH.
- Tratamiento inicial: tranquilizar, suspender gatillantes (cafeína, alcohol, tabaco, estimulantes, privación de sueño); si síntomas molestos, betabloqueador (propranolol o bisoprolol).
- Señales de alarma: síncope, cardiopatía estructural, carga >10–20% (riesgo de miocardiopatía), polimorfas, salvas o TV no sostenida → derivar a cardiología.
- Seguimiento completo en APS de las formas benignas: control clínico y Holter de control si aumentan los síntomas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 35 años, sin antecedentes, consulta por sensación de 'saltos' en el pecho en reposo, que desaparecen al hacer ejercicio. Examen físico normal. El ECG muestra extrasístoles ventriculares aisladas, monomorfas, sin otras alteraciones. El ecocardiograma es normal y el Holter muestra 2% de extrasístoles ventriculares aisladas, sin taquicardia ventricular. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tranquilizar, reducir cafeína y alcohol, y control clínico
B Amiodarona oral
C Derivar para ablación urgente
D Implantar un desfibrilador
E Iniciar flecainida

Respuesta A. Extrasístoles ventriculares aisladas y monomorfas que desaparecen con el ejercicio, con corazón estructuralmente normal y baja carga en el Holter, son benignas: basta educar y suprimir gatillantes. Si son muy molestas, se usa un betabloqueador. Amiodarona o flecainida no están indicadas y son proarrítmicas.

▶ VER CLASE 1.01.1.012 Fibrilación auricular crónica

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 1.3 · Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)

QUÉ HAY QUE SABER

- FA: ritmo irregularmente irregular sin ondas P, con línea de base fibrilatoria; la arritmia sostenida más frecuente. Permanente/crónica cuando se decide no restablecer el ritmo sinusal.
- Estudio: ECG, ecocardiograma, TSH, función renal, electrolitos y hemograma; buscar HTA, valvulopatía, IC, alcohol, hipertiroidismo y SAHOS.
- Riesgo embólico con CHA2DS2-VASc: anticoagular si ≥2 en hombres o ≥3 en mujeres (considerar con 1/2). DOAC de elección (apixabán 5 mg c/12 h, rivaroxabán 20 mg/día); acenocumarol (INR 2–3) si estenosis mitral o prótesis mecánica.

- La aspirina NO previene el ACV en FA. Evaluar riesgo hemorrágico (HAS-BLED) para corregir factores modificables, no para negar la anticoagulación.
- Control de frecuencia (meta <110 lpm en reposo): betabloqueador (bisoprolol, carvedilol) o diltiazem/verapamilo si FEVI conservada; digoxina como complemento en IC o sedentarios.
- Seguimiento completo en APS: FC, síntomas, adherencia, INR mensual si AVK, función renal anual (o más frecuente) para ajustar DOAC, sangrados.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 150

Paciente de 70 años, con antecedente de EPOC tabáquico, presenta cuadro de 3 meses de aumento de su disnea basal asociado a palpitaciones. Al examen físico destaca frecuencia cardiaca de 100 por minuto, ritmo cardiaco irregular con ausencia de soplos y murmullo pulmonar presente con roncus y sibilancias difusas. Se realiza electrocardiograma que muestra ausencia de onda “p”, de forma irregular y presencia de QRS angosto. ¿Cuál de los siguientes fármacos estará contraindicado para el manejo de este paciente?

A Verapamilo
B Lanantósido C
C Losartán
D Amiodarona
E Carvedilol

Respuesta E. La opción correcta es la E (Carvedilol). En este escenario clínico, carvedilol se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 97

Mujer de 78 años con fibrilación auricular permanente no valvular, CHA_2DS_2-VASc de 4. Sin antecedente de hemorragia. ¿Cuál es el manejo antitrombótico más adecuado?

A Anticoagulación oral con apixabán o rivaroxabán
B Aspirina 100 mg/día
C No anticoagular por edad avanzada
D Heparina de bajo peso molecular
E Clopidogrel + aspirina

Respuesta A. FA no valvular con CHA_2DS_2-VASc ≥2 en mujer: anticoagulación oral indicada. ACODs (apixabán, rivaroxabán) son preferibles a warfarina en el adulto mayor por menor riesgo de hemorragia intracraneal.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 74 años, hipertenso y diabético, en control en APS por fibrilación auricular permanente con FC de 84 lpm en tratamiento con bisoprolol. Ecocardiograma: FEVI 55%, sin valvulopatía significativa. Creatinina 1,0 mg/dL. Solo toma aspirina 100 mg como antitrombótico. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la prevención de embolía?**

A Mantener aspirina 100 mg/día
B Agregar clopidogrel a la aspirina
C Cardioversión eléctrica sin anticoagulación previa
D Suspender aspirina e iniciar apixabán 5 mg cada 12 horas
E No requiere antitrombótico por tener frecuencia controlada

Respuesta D. Su CHA2DS2-VASc es 3 (edad 65–74, HTA y DM), lo que indica anticoagulación oral; en FA no valvular el DOAC es de elección. La aspirina no previene el ACV en FA y la doble antiagregación es inferior a la anticoagulación.

▶ VER CLASE `1.01.1.013` **Fibrilación auricular paroxística** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 1.3 · Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)

QUÉ HAY QUE SABER

- FA paroxística: episodios autolimitados <7 días (habitualmente <48 h) de palpitaciones irregulares, disnea, mareo o dolor torácico; confirmar con ECG durante el episodio o Holter.
- Evaluar estabilidad: hipotensión, isquemia, IC aguda o compromiso de conciencia → cardioversión eléctrica sincronizada inmediata.
- Estable <48 h (o anticoagulado ≥3 semanas o ETE sin trombo): se puede cardiovertir; amiodarona si hay cardiopatía estructural, flecainida/propafenona solo en corazón sano. >48 h o duración incierta: anticoagular 3 semanas antes y 4 semanas después.
- Control de frecuencia inicial con betabloqueador o diltiazem (este último contraindicado en IC con FEVI reducida); buscar gatillantes: alcohol, hipertiroidismo, infección, SAHOS.
- La anticoagulación se decide con CHA2DS2-VASc igual que en la FA permanente: la carga de FA paroxística no reduce el riesgo embólico.
- Seguimiento: derivar a cardiología para estrategia de control de ritmo (antiarrítmicos o ablación con catéter).

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 128

Paciente con ECG que muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida (130 lpm) y función ventricular conservada. Hemodinámicamente estable. ¿Cuál es el fármaco de elección para control de frecuencia?

A Metoprolol oral
B Amiodarona EV
C Digoxina EV
D Flecainida oral
E Sotalol oral

Respuesta A. FA con respuesta ventricular rápida estable y FEVI conservada: control de frecuencia con betabloqueador (metoprolol) o calcioantagonista (diltiazem/verapamilo). Metoprolol es primera línea.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 154

Un hombre de 35 años consulta por palpitaciones intensas, que iniciaron tras 4 días de consumo abundante de alcohol. Al examen físico se palpa pulso irregular a 160 latidos por minuto y se constata presión arterial de 105/67 mmHg. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Taquicardia sinusal
B Taquicardia paroxís2ca supraventricular
C Taquicardia ventricular
D Fibrilación auricular
E Taquicardia auricular mul2focal

Respuesta D. Por ser irregular, lo más probable es que sea una fibrilación auricular (FA), que, por cierto es muy frecuente. La taquicardia sinusal y la TPSV son regulares. La taquicardia ventricular puede ser regular o irregular, pero suele ser mucho más grave y tener alguna patología de base. La TAMF es irregular, pero es mucho menos frecuente. De todos modos, se debe realizar un electrocardiograma para confirmar el diagnóstico. El manejo de la FA aguda es 0. Si hemodinamia inestable: cardioversión...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 92

Un paciente de 73 años, diabético e hipertenso, en tratamiento farmacológico con enalapril, hidroclorotiazida, glibenclamida y metformina, presenta crisis de palpitaciones que duran 1 a 4 horas y que se han repetido en 5 ocasiones, durante las últimas semanas. Actualmente su examen físico muestra una frecuencia cardíaca es 62x', regular; su presión arterial, 133/83 mmHg y su examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en dos tonos, sin soplos y murmullo pulmonar presente, simétrico, sin otros ruidos. A continuación, se muestra un electrocardiograma tomado durante una de las crisis: Foto 7 (https://www.emedicinehealth.com/XXXXXXXXXX/article_em.htm). ¿Qué fármaco es el más importante agregar en este momento?

A Antiagregantes
B Adenosina
C Verapamilo
D Acenocumarol
E Betabloqueantes

Respuesta D. Tiene una fibrilación auricular paroxística. Tiene baja frecuencia cardíaca, por lo que no se debe iniciar verapamilo ni betabloqueo. Por ser hipertenso y diabético, tien 2 puntos del CHADS2, por lo que se debe anticoagular.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 173

Una mujer de 62 años, consulta por un cuadro de 3 horas de evolución de palpitaciones intensas, asociada a disnea. Al examen físico tiene pulso irregular, a 130 latidos por minuto, con PA: 110/70 mmHg. Su examen cardíaco muestra soplo diastólico III/VI, más un pequeño soplo sistólico eyectivo. Su electrocardiograma muestra una taquicardia irregular, con complejos QRS angostos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Administrar propanolol y antiagregantes
B Administrar enoxiheparina y verapamilo
C Administrar heparina y amiodraona
D Realizar cardioversión eléctrica
E Administrar adenosina y anticoagulantes orales

Respuesta B. Es una fibrilación auricular de menos de 48 horas, rápida pero sin compromiso hemodinámico, y el soplo diastólico sugiere una valvulopatía mitral de base, que eleva mucho el riesgo embólico. Corresponde anticoagular (heparina de bajo peso molecular) y controlar la frecuencia con un calcioantagonista no dihidropiridínico como verapamilo. No hay inestabilidad que justifique cardioversión eléctrica, la adenosina solo sirve en la taquicardia paroxística supraventricular y los antiagregantes no...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 45

Paciente de 35 años de edad, consulta por cuadro de 2 días de palpitaciones de dos días de evolución asociado a disnea en algunas ocasiones. Al ingreso se conecta a monitor donde se observa presencia de taquiarritmia irregular de complejo angosto. Al examen físico se encuentra consciente y orientada temporoespacialmente, bien perfundida e hidratada, examen pulmonar normal. La conducta más adecuada en este caso es:

A Realizar cardioversión eléctrica

B Indicar enoxaparina y amiodarona

C Indicar acenocumarol y betabloqueo

D Indicar heparina de bajo peso molecular y verapamilo

E Indicar heparina no fraccionada y flecainida

Respuesta D. Tiene una FA rápida, mayor a 48 horas. Se debe anticoagular y controlar la FC mientras tanto. Siempre se inicia la anticoagulación con heparina (es mejor la de bajo peso). Para controlar la FC tenemos propanolol, digital y verapamilo. Aún así, esta pregunta es muy discutible, ya que por no tener ningún criterio de CHADS2, incluso se podría no anticoagular. Sin emabargo no hay que rebuscarse y hay que simplificar la pregunta a ¿cómo se maneja una FA de más de 48 horas?. También se puede criticar...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 1

Paciente de 53 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento con enalapril, consulta por disnea de medianos esfuerzos asociado a palpitaciones intermitentes desde hace un mes. Al examen físico destaca ritmo irregular asociado a aumento de R1. El diagnóstico más probable es:

A Flutter auricular

B Taquicardia ventricular

C Taquicardia paroxística supraentricular

D Fibrilación auricular

E Enfermedad del nodo sinusal

Respuesta D. Diagnóstico: Fibrilación auricular (opción D). Tiene una Estrenosis Mitral con FA. La presencia de pulso irregularmente irregular (arritmia completa), palpitaciones y disnea orienta de forma decisiva a fibrilación auricular. El antecedente de sobrecarga o valvulopatía (R1 reforzado por estenosis mitral o dilatación auricular izquierda por HTA) es el principal detonante anatómico y arritmogénico según el Perfil V3 EUNACOM.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años, sin antecedentes, consulta en urgencia por palpitaciones irregulares de 6 horas de evolución. PA 125/80 mmHg, FC 138 lpm, sin disnea ni dolor torácico. ECG: ritmo irregular sin ondas P, QRS estrecho. Ecocardiograma de urgencia sin cardiopatía estructural. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Anticoagular por 3 semanas antes de intentar cardioversión

B Cardioversión farmacológica con flecainida o propafenona

C Cardioversión eléctrica inmediata por inestabilidad

D Adenosina 6 mg en bolo EV

E Digoxina EV como único tratamiento y alta

Respuesta B. FA de <48 horas, hemodinámicamente estable y con corazón sano: se puede intentar cardioversión farmacológica con antiarrítmicos IC. La anticoagulación previa de 3 semanas es para FA >48 h o de duración incierta; la adenosina no sirve en FA.

▶ VER CLASE 1.01.1.014 Flutter auricular

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 1.3 · Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)

QUÉ HAY QUE SABER

- Flutter auricular típico: macrorreentrada en la aurícula derecha; ECG con ondas F en 'dientes de sierra' en DII, DIII y aVF a ~300 lpm y conducción 2:1 (FC regular ~150 lpm).
- Sospechar ante taquicardia regular de QRS estrecho a 150 lpm fija; maniobras vagales o adenosina enlentecen la respuesta y desenmascaran las ondas F (no la revierten).
- Inestable: cardioversión eléctrica sincronizada (responde a baja energía, 50–100 J). Estable: control de frecuencia con betabloqueador o diltiazem, más difícil que en FA.
- Mismo riesgo embólico que la FA: anticoagulación según CHA2DS2-VASc y 3 semanas de anticoagulación antes de cardiovertir si >48 h.
- Asociado a EPOC, cirugía cardíaca, valvulopatías y FA; puede alternar con ella.
- Seguimiento: derivar a cardiología; la ablación del istmo cavotricuspídeo es curativa en el flutter típico (>90%).

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 137

Un paciente de 71 años, con antecedente de reemplazo valvular tricuspídeo, secundario a una endocarditis bacteriana, con prótesis biológica in situ consulta por consulta por palpitaciones muy intensas, asociadas a disnea. Al examen físico tiene un pulso a 140 latidos por minutos, regular. Se realizan maniobras vagales (masaje carotídeo) y se observa el siguiente electrocardiograma (fuente: slideshare): El diagnóstico más probable es:

A Taquicardia paroxística supraventricular
B Fibrilación auricular
C Flutter auricular
D Síndrome de Wolff Parkinson White
E Taquicardia auricular

Respuesta C. En las últimas dos derivaciones se ven claramente las ondas de serrucho (que aparecen con la maniobra vagal, ya que bradicardiza y aumenta el bloqueo AV), características del flutter.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 95

Un paciente de 40 años, con antecedente de reemplazo valvular, secundario a una endocarditis bacteriana, consulta por consulta por palpitaciones muy intensas, asociadas a disnea. Al examen físico tiene un pulso a 140 latidos por minutos, regular. Se realizan maniobras vagales (masaje carotídeo) y se observa el siguiente electrocardiograma: Foto 9 (https://www.slideshare.net/XXXXchandrabarik/svtalogarythm). El diagnóstico más probable es:

A Taquicardia paroxística supraventricular
B Fibrilación auricular
C Flutter auricular
D Síndrome de Wolff Parkinson White
E Taquicardia auricular

Respuesta C. Con las maniobras vagales baja la frecuencia, se ven las ondas de serrucho y luego vuelve a aumentar la frecuencia. Es lo clásico del flutter auricular.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 180

Una paciente de 44 años, con antecedente de estenosis mitral consulta por palpitaciones rápidas, intensas, regulares, asociadas a disnea y malestar general. Se realiza masaje carotídeo, observándose el siguiente trazado en el electrocardiograma: Fuente: https://empendium.com/manualmibe/chapter/B34.II.2.6.7. El diagnóstico más probable es:

A Taquicardia paroxística supraventricular
B Fibrilación ventricular
C Taquicardia sinusal
D Flutter auricular
E Taquicardia ventricular

Respuesta D. Diagnóstico: Flutter auricular (opción D). Es un flutter o aleteo auricular clásico, con las ondas de serrucho. El flutter auricular es una taquicardia supraventricular producida por un circuito de macrorreentrada auricular, más frecuentemente en la aurícula derecha alrededor del anillo tricuspídeo (flutter típico).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años con EPOC consulta por palpitaciones de 2 días. PA 130/80 mmHg, FC 150 lpm regular. ECG: ondas en dientes de sierra en DII, DIII y aVF, frecuencia auricular 300 lpm, conducción 2:1. **¿Cuál es el diagnóstico?**

A Taquicardia sinusal
B Taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal
C Taquicardia ventricular
D Taquicardia auricular multifocal
E Flutter auricular típico

Respuesta E. Ondas F en dientes de sierra a 300 lpm en derivaciones inferiores con conducción 2:1 (FC fija de 150) son diagnósticas de flutter auricular típico. Al llevar más de 48 horas, requiere anticoagulación antes de cardiovertir si está estable.

▶ VER CLASE **1.01.1.015** **Hipertensión arterial esencial** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 5.1 · Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico: perfil de PA con PA ≥140/90 mmHg en al menos 2 mediciones adicionales en días distintos; MAPA o automedición si se sospecha HTA de delantal blanco o enmascarada. PA ≥180/110 confirma en una consulta.
- Estudio inicial: creatinina con VFG, electrolitos, glicemia, perfil lipídico, ácido úrico, orina completa, RAC y ECG; buscar daño de órgano blanco (HVI, retinopatía, albuminuria).
- Cambios de estilo de vida para todos: sal <5 g/día, dieta DASH, bajar de peso, actividad física 150 min/semana, limitar alcohol, dejar tabaco.
- Fármacos de primera línea: IECA (enalapril 10–20 mg c/12 h) o ARA-II (losartán 50–100 mg/día), calcioantagonista (amlodipino 5–10 mg) o tiazida (hidroclorotiazida 12,5–25 mg); combinación dual si PA ≥160/100 o alto riesgo.
- Metas: PA <140/90 mmHg en general y <130/80 en alto riesgo cardiovascular (DM, ERC con albuminuria) si se tolera; en ≥80 años, PAS <150 mmHg. GES para personas ≥15 años.

- Seguimiento completo en APS (Programa de Salud Cardiovascular): controles periódicos, adherencia, laboratorio anual; derivar si HTA resistente (≥3 fármacos incluido diurético) o sospecha de causa secundaria.

PREGUNTAS · 15

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 5.1

Hombre de 52 años hipertenso inicia tratamiento con Enalapril 20 mg al día. En el control a las 2 semanas se pesquisa elevación de la Creatinina plasmática desde 1.0 mg/dL basal hasta 2.4 mg/dL. A la auscultación abdominal se pesquisa un soplo sistólico en el flanco izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Estenosis de la arteria renal aterosclerótica
B Hiperaldosteronismo primario (Conn)
C Nefropatía diabética incipiente
D Glomerulonefritis membranosa
E Necrosis tubular aguda tóxica

Respuesta A. El deterioro brusco de la función renal (alza de creatinina > 30-50%) tras la introducción de un IECA o ARA2, sumado a la auscultación de un soplo abdominal en el flanco, es patognomónico de la Estenosis Bilateral de la Arteria Renal o unilateral en riñón único, al eliminarse la vasoconstricción de la arteriola eferente mediada por angiotensina II.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 65

Un paciente de 85 años, hipertenso, está en tratamiento con losartan 50 mg/12 horas y amlodipino 2,5 mg/día. Acude a control y refiere múltiples tomas de presión arterial, las que promedian 145/75 mmHg ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Aumentar la dosis de losartán a 100 mg/12 horas
B Aumentar el amlodipino a 5 mg/día
C Agregar atenolol 12,5 mg/día
D Agregar hidroclorotiazida 25 mg/día
E Mantener el tratamienti

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Mantener el tratamienti (opción E). Por su edad, está bien controlado, ya que la meta es que sea menor a 150/90 mmHg.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 177

Un paciente de 45 años, con IMC de 32 kg/m², acude a control médico, objetivándose presión arterial de 146/92 mmHg. Se solicita Holter de presión arterial, que muestra múltiples registros sobre 140/90 mmHg, diagnosticándose hipertensión arterial. Sus exámenes de laboratorio resultan normales, incluyendo función renal, electrolitos plasmáticos y electrocardiograma. ¿Qué tipo de fármacos es el más adecuado para iniciar el tratamiento antihipertensivo en este paciente?

A Bloqueadores alfa-adrenérgicos
B Bloqueadores beta-adrenérgicos
C Inhibidores del canal de calcio
D Antagonistas del receptor de angiotensina
E Diuré2cos 2azídicos

Respuesta D. Además de obesidad, con alta probabilidad Gene una hipertensión esencial, ya que no Gene elementos que hagan sospechar una causa secundaria. En pacientes jóvenes se suele iniciar con IECA (inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina) o ARA2 (antagonistas del receptor de angiotensina 2). Muchas guías actuales prefieren iniciar con dos fármacos de forma simultánea (ej. losartán + amlodipino). Aunque IECA y ARA2 Genen resultados comparables, muchos pacientes prefieren el losartán sobre...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 32

Hombre de 55 años hipertenso en tratamiento con enalapril, bien controlado. Consulta por tos seca persistente desde que inició el tratamiento hace 3 meses. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Amlodipino (mantener enalapril y agregar calcioantagonista)
B Hidroclorotiazida (agregar diurético)
C Losartán (cambiar enalapril por ARA II)
D Atenolol (agregar betabloqueador)
E Suspender enalapril sin reemplazar

Respuesta C. Tos seca por IECA (enalapril): efecto de clase por acumulación de bradicinina, ocurre en 10-15% de pacientes. Solución: cambiar a ARA II (Losartán, Valsartán) que no causan tos. El control hipertensivo se mantiene con igual eficacia sin el efecto adverso.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 85

Paciente con HTA en triple terapia (IECA, amlodipino, HCTZ), con edema en extremidades inferiores y presión 120/70. ¿Cuál es la conducta?

A Agregar furosemida oral
B Suspender amlodipino
C Reducir dosis de IECA
D Agregar espironolactona
E Derivar a cardiología por insuficiencia cardíaca

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Suspender amlodipino (opción B). Suspender amlodipino.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 180

Paciente con HTA sobre el rango normal en tratamiento actual, ¿cuál es el medicamento más adecuado a agregar?

A Amlodipino
B Valsartán (ARA II)
C Hidroclorotiazida
D Carvedilol
E Furosemida

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Valsartán (ARA II) (opción B). Valsartán (ARA II).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 122

Un paciente de 69 años, con antecedente de diabetes e hipertensión, en tratamiento con aspirina, losartán, amlodipino, hidroclorotiazida y metformina, consulta por sensación de hinchazón y molestias en las extremidades inferiores. Al examen físico, tiene edema de extremidades inferiores. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Suspender el amlodipino
B Aumentar la dosis de hidroclorotiazida
C Disminuir la dosis de metformina
D Suspender el losartán
E Aumentar la dosis de aspirina

Respuesta A. El edema de EEII hace que probablemente sea un efecto adverso del amlodipino, por lo que se debe suspender.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 51

Una paciente de 67 años, hipertensa, en tratamiento con losartán 50 mg, hidroclorotiazida 25 mg, amlodipino 5 mg, carvedilol 12,5 mg. Presenta edema de las extremidades inferiores, que ha ido en aumento. En su examen físico tiene FC: 57x' regular, con PA: 130/90 mmHg, RR2T, examen pulmonar sin alteraciones y examen abdominal con hígado palpable 1 cm bajo el reborde costal y extremidades inferiores con edema bimaleolar con signo de la fóvea. La conducta más adecuada es:

A Reforzar la dieta hiposódica e indicar reposo con las extremidades en alto
B Suspender el amlodipino
C Subir la dosis del diurético
D Suspender el losartán y agregar doxazosina
E Solicitar ecodoppler de extremidades inferiores

Respuesta B. En este caso tiene un efecto adverso del amlodipino: edema, por lo que que hay que suspenderlo. Aunque la A y la C podrían servir, se debe siempre suspender y reemplazar el medicamento que produzca un efecto adverso, en la medida de lo posible, antes de tomar otras medidas (esto aplica para medicina en general).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 14

Una paciente de 53 años, diabética tipo 2, es diagnosticada recientemente de hipertensión. Sus exámenes generales, incluyendo un electrocardiograma, no muestran alteraciones ¿Qué fármaco es más adecuado para su tratamiento?

A Atenolol
B Hidroclorotiazida
C Carvedilol
D Amlodipino
E Enalapril

Respuesta E. Tanto por ser menor de 55 años, como especialmente por ser diabética, el antihipertensivo de elección son los IECAs (enalapril).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 9

Un paciente de 63 años, diabético y dislipidémico, en tratamiento con metformina, atorvastatina y aspirina, se realiza varias tomas de presión arterial, que resultan 170/100 mmHg en promedio. Se realiza exámenes que muestran creatinina: 1,1 mg/dl, proteinuria (+), glucosuria (++), potasemia: 4,0 mEq/L, natremia: 142 mEq/L, glicemia: 115 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Iniciar amlodipino
B Iniciar hidroclorotiazida
C Iniciar enalapril
D Iniciar hidralazina
E Iniciar atenolol

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Iniciar enalapril (opción C). La HTA en un diabético se trata con IECAs como primera línea. También la proteinuria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 86

Adulto mayor hipertenso con cardiopatía coronaria, en tratamiento con carvedilol, atorvastatina e HCTZ, presiones elevadas con función renal y potasio normales. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A Amlodipino
B Hidralazina
C Metildopa
D Nifedipino de liberación prolongada
E Losartán

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Losartán (opción E). Losartán.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 78

Paciente HTA en tratamiento con atenolol e hidroclorotiazida, metas fuera de rango con proteinuria que hipotensor es el indicado: a. Enalapril.

A Amoxicilina
B Ibuprofeno
C Paracetamol
D Omeprazol
E Metformina

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Amoxicilina (opción A).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 105

Un paciente de 56 años, diabético en tratamiento con metformina 500 mg/8 horas, con hipertensión de reciente diagnóstico, se realiza exámenes de control, que muestran creatinina plasmática: 0,9 mg/dl, BUN: 18 mg/dl, electrolitos plasmáticos: Na+: 141 mEq/L y K+: 4,1 mEq/l, RAC (relación albuminuria / creatininuria): 2,6 y hemoglobina glicosilada: 6,9%. ¿Qué fármaco es el más adecuado para el tratamiento de su hipertensión arterial?

A Hidralacina
B Espironolactona
C Amlodipino
D Atenolol
E Valsartán

Respuesta D. Diagnóstico: Atenolol (opción D). Clase sobre las familias de antihipertensivos, sus efectos adversos, contraindicaciones y criterios de elección.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 144

Un paciente diabético de larga data en tratamiento con empagliflozina 10 mg al día, metformina 1.000 mg cada 8 horas y atorvastatina 20 mg al día, presenta presiones arteriales de 140/90 mmHg y 158/87 mmHg en dos controles diferentes. El resto de su examen físico es normal y trae exámenes, entre los que destaca hemoglobina glicosilada de 6.9%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Iniciar terapia depletiva de potasio
B Iniciar tratamiento antihipertensivo
C Solicitar un monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)
D Iniciar terapia antiagregante plaquetaria
E Iniciar insulina

Respuesta B. Hipertensión en Paciente Diabético: Aunque se recomiendan tres tomas de presión arterial o un monitoreo ambulatorio de 24 horas para diagnosticar hipertensión, dos tomas pueden ser suficientes en pacientes diabéticos si hay alta sospecha. El objetivo de presión arterial en estos pacientes es menor a 130/80 mmHg, por lo que está claramente sobre esos valores. El tratamiento inicial recomendado en diabéticos son los antihipertensivos IECA o ARA II.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 36

Una paciente de 60 años con antecedente de hipertensión arterial de larga data, en tratamiento con carvedilol 25 mg cada 12 horas e hidroclorotiazida 50 mg/día, presenta presiones arteriales cercanas a 150/95 en la mayoría de las tomas. Además, tiene disnea de grandes esfuerzos y ortopnea, que lo obliga a dormir con una almohada grande. Su examen físico tiene frecuencia cardíaca 66x', PA: 150/96 mmHg, saturación arterial de oxígeno de 97%, examen pulmonar con crepitaciones bibasales, sin otras alteraciones y examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos, sin soplos. Se solicitan exámenes que muestran natremia: 142 mEq/L, potasemia: 4,0 mEq/L, creatininemia: 0,7 mg/dl, con hemograma y pruebas tiroideas normales. ¿Qué fármaco debería agregarse en este caso?

A Losartán
B Amlodipino
C Verapamilo
D Diltiazem
E Doxazosina

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Doxazosina (opción E).

▶ VER CLASE **1.01.1.016** **Hipertensión arterial secundaria** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 5.1 · Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar HTA secundaria si: inicio <30 años o >55 años, HTA resistente o de difícil control, crisis hipertensivas, hipokalemia espontánea, daño de órgano desproporcionado o alza brusca de creatinina con IECA.
- Hiperaldosteronismo primario (la causa endocrina más frecuente): HTA resistente + hipokalemia; tamizaje con relación aldosterona/actividad de renina plasmática.
- Estenosis de arteria renal: soplo abdominal, edema pulmonar flash, deterioro renal con IECA/ARA-II; ateromatosa en ancianos, displasia fibromuscular en mujeres jóvenes. Estudio con Eco-Doppler o angioTAC.
- Feocromocitoma: crisis de cefalea, sudoración y palpitaciones → metanefrinas plasmáticas o urinarias. Otras: SAHOS (polisomnografía), ERC, hipotiroidismo/hipertiroidismo, Cushing, coartación aórtica, fármacos (AINE, ACO, corticoides).
- Manejo inicial: controlar la PA (calcioantagonista o espironolactona si sospecha de hiperaldosteronismo; evitar betabloqueador solo en feocromocitoma) y suspender fármacos hipertensores.
- Seguimiento: derivar a especialista (nefrología, endocrinología o cardiología según la sospecha) para confirmación y tratamiento específico.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 171

Un paciente de 37 años acude a chequeo médico en el que destaca presión arterial de 170/110 mmHg. No tiene obesidad ni antecedentes familiares de hipertensión. Se solicita un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, confirmándose el diagnóstico de hipertensión arterial, por lo que se inicia losartán 50 mg al día y amlodipino 5 mg al día. Se controla un mes después y el paciente refiere que ha mantenido presiones arteriales cercanas a 160/100 mmHg. Los exámenes de laboratorio muestran creatininemia: 0,9 mg/dL, BUN: 12 mg/dL, sodio plasmático: 140 mEq/L y potasio plasmático: 4,4 mEq/L. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Aumentar la dosis de los fármacos
B Agregar un diurético al tratamiento
C Solicitar ecografía Doppler renal
D Solicitar niveles plasmáticos de aldosterona
E Solicitar metanefrinas y catecolaminas en orina

Respuesta D. HTA severa en un joven sin obesidad ni antecedentes familiares: sospecha de HTA secundaria. Por la edad, la causa más probable es el hiperaldosteronismo primario, que se estudia con aldosterona (idealmente como RAR). El potasio normal no lo descarta, sobre todo si usa ARA II.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 51

Un paciente de 40 años, con antecedente de hipertensión arterial diagnosticada hace 6 meses, de difícil manejo, acude a control. Toma hidroclorotiazida 50 mg/día, losartán 100 mg/día y amlodipino 10 mg/día. Refiere varias crisis hipertensivas, a pesar de una buena adherencia a su tratamiento farmacológico. En el examen físico, su presión arterial actual es 158/97, que es similar a los valores que habitualmente presenta en su casa; su frecuencia cardíaca es 65x' y su examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en dos tiempos, sin soplos y murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Trae un monitoreo de presión arterial con presión arterial promedio de 160/101 mmHg, con que muestra cargas tensionales diurnas de 77% sistólica y 63% diastólica y cargas tensionales nocturnas de 67% sistólica y 56% diastólica. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Reemplazar el losartán por un IECA
B Reemplazar la hidroclorotiazida por un diurético antialdosterónico
C Agregar doxazosina al tratamiento
D Agregar espironolactona y solicitar exámenes para descartar una hipertensión secundaria
E Reemplazar el amlodipino por diltiazem

Respuesta D. Tres fármacos a dosis plenas, uno de ellos diurético, con buena adherencia y monitoreo que confirma presiones altas: HTA resistente. Se agrega espironolactona como cuarto fármaco y se estudia una causa secundaria, partiendo por el hiperaldosteronismo primario.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 81

Paciente con HTA en tratamiento triple (enalapril, amlodipino e hidroclorotiazida) con presiones elevadas persistentes. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Aumentar dosis de enalapril al máximo
B Agregar beta-bloqueador oral
C Suspender hidroclorotiazida y agregar furosemida
D Derivar a nefrología de urgencia
E Agregar espironolactona e iniciar estudio de HTA secundaria

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Agregar espironolactona e iniciar estudio de HTA secundaria (opción E). Agregar espironolactona e iniciar estudio de HTA secundaria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 136

Un paciente de 38 años, diagnosticado de hipertensión arterial, está en tratamiento con enalapril 20 mg c/12 horas, hidroclorotiazida 25 mg/d y amlodipino 10 mg/día. Se realiza control con monitoreo de 24 horas de presión arterial que muestra presiones arteriales diurnas promedio de 152/100 mmHg, con sobrecarga tensional de 60% sistólica y 43% diastólica y presiones arteriales nocturnas de 140/92 mmHg, con sobrecarga tensional de 25% sistólica y 27% diastólica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Aumentar la dosis de hidroclorotiazida

B Aumentar la dosis de enalapril

C Iniciar inhibidor del receptor de aldosterona y descartar hipertensión secundaria

D Reemplazar el enalapril por losartán

E Reemplazar la hidroclorotiazida por un inhibidor del receptor de aldosterona

Respuesta C. Tiene una HTA refractaria, ya que está tratada con 3 fármacos, incluyendo un diurético, en dosis altas (la HCTZ se puede aumentar a 50 mg, pero sigue siendo una HTA refractaria este caso). Por tanto, se debe agregar espironolactona y buscar una causa secundaria. Además, como dato, la sobrecarga tensional muestra el tiempo que están las presiones sobre el valor normal (se llama HTA enmascarada o "hipertensión del delantal blanco INVERSO" cuando las presiones arteriales son normales en la...

▶ VER CLASE **1.01.1.017** **Insuficiencia aórtica** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 4.2 · Insuficiencia Aórtica & Estenosis Mitral Reumática

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia aórtica: causas válvula bicúspide, degenerativa, endocarditis, dilatación de raíz (Marfan, HTA), fiebre reumática; aguda por endocarditis o disección aórtica.
- Crónica: presión diferencial amplia (ej. 160/50), pulso céler (Corrigan), soplo diastólico aspirativo en borde esternal izquierdo, signos de Musset, Quincke y Duroziez; soplo de Austin Flint.
- Confirmación con ecocardiograma: severidad, FEVI y diámetros del VI. ECG con HVI por sobrecarga de volumen; Rx con cardiomegalia.
- Manejo inicial de la crónica: vasodilatadores (IECA/ARA-II o amlodipino) si HTA; tratar IC. La aguda es emergencia quirúrgica (EAP y shock): estabilizar y trasladar.
- Indicación quirúrgica en IAo severa: síntomas, FEVI ≤50% o dilatación del VI (diámetro sistólico >50 mm), con garantía GES de cirugía valvular.
- Seguimiento: derivar a cardiología; ecocardiograma seriado para detectar deterioro de la función del VI antes de los síntomas.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 4.2

Hombre de 48 años hipertenso con soplo cardíaco presenta al examen PA 170/45 mmHg, pulso de ascenso rápido y colapso súbito (pulso céler) y oscilación de la cabeza rítmica con el pulso (signo de Musset). ¿Cuál es la valvulopatía causante?

A Insuficiencia aórtica severa

B Estenosis aórtica severa

C Insuficiencia mitral severa

D Estenosis pulmonar

E Coartación aórtica

Respuesta A. La presión diferencial sumamente amplia (170/45 mmHg) asociada al pulso saltón o de Corrigan y a signos periféricos hiperdinámicos (Musset, Quincke) es patognomónica de la Insuficiencia Aórtica Crónica Severa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 71

Pregunta 71 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente de 81 años consulta por disnea de esfuerzos, progresiva, asociada a paroxística nocturna y ortopnea. Al examen físico se objetiva PA: 160/60 mmHg, con pulso regular, amplio, a 72 lpm. Su examen cardíaco muestra desplazamiento del choque cardíaco, con presencia de un soplo intenso, entre el segundo y el primer ruido cardíaco, que se irradia al cuello. El examen pulmonar muestra crepitaciones escasas, en ambas bases. El diagnóstico de sospecha es:

A Insuficiencia tricuspídea

B Estenosis aórtica

C Insuficiencia aórtica

D Estenosis mitral

E Insuficiencia mitral

Respuesta C. Diagnóstico: Insuficiencia aórtica (opción C). Es una insuficiencia aórtica clásica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 147

Adulto con disnea de esfuerzos progresiva, diferencia PA sistólica-diastólica amplia, pulsos amplios y soplo diastólico aspirativo. ¿Diagnóstico más probable?

A Estenosis aórtica severa
B Estenosis mitral con hipertensión pulmonar
C Insuficiencia aórtica
D Insuficiencia mitral crónica
E Comunicación interventricular del adulto

Respuesta C. Diagnóstico: Insuficiencia aórtica (opción C). Insuficiencia aórtica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 2

Un paciente masculino de 23 años, sin antecedentes de importancia consulta por disnea de esfuerzos e intolerancia al ejercicio, progresiva, que actualmente le obligan a caminar más lento. Al examen físico tiene FC: 88x', PA: 150/55 mmHg, choque de la punta en la línea axilar media y latido cervical visible. La auscultación cardíaca muestra ritmo regular, en dos tiempos, con un soplo diastólico IV/VI, con frémito. Al examen pulmonar, se constatan crépitos pulmonares. El diagnóstico más probable es:

A Insuficiencia mitral
B Estenosis aórtica
C Estenosis mitral
D Insuficiencia aórtica
E Miocardiopatía hipertrófica

Respuesta D. Diagnóstico: Insuficiencia aórtica (opción D). Es una insuficiencia aórtica clásica (ver resumen de semiología cardíaca).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 91

Un paciente de 18 años, con antecedente de coartación aórtica, operada en la infancia, consulta por disnea de esfuerzos, que ha ido en aumento, desde hace 2 meses. Además, refiere edema de extremidades inferiores y palpitaciones ocasionales. Al examen físico tiene FC: 88x', PA: 155/55 mmHg, el choque de la punta se palpa hiperdinámico, en la línea media axilar y en la auscultación cardíaca se constata soplo sistólico eyectivo II/VI, más un soplo diastólico III/VI, que dura toda la diástole. Su examen pulmonar muestra crépitos escasos en ambas bases. El diagnóstico más probable es:

A Estenosis aórtica
B Insuficiencia aórtica
C Recoartación aórtica
D Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
E Miocardiopatía dilatada

Respuesta B. Diagnóstico: Insuficiencia aórtica (opción B). También era una insuficiencia aórtica clásica (ver resumen de semiología cardíaca).

▶ VER CLASE `1.01.1.018` **Insuficiencia cardíaca**

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Cardiología 3.1 · Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham
Cardiología 3.2 · Cuádruple Terapia GDMT en IC-FEr (Guía GES 2026)
Nefrología 1.4 · Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico clínico por criterios de Framingham (2 mayores o 1 mayor + 2 menores): DPN, ortopnea, ingurgitación yugular, crépitos, R3, cardiomegalia, reflujo hepatoyugular; menores: edema, hepatomegalia, derrame, tos nocturna.
- Confirmación: BNP <100 pg/mL o NT-proBNP <300 descarta IC aguda; ecocardiograma define el fenotipo: FEVI reducida ≤40%, levemente reducida 41–49%, preservada ≥50%.
- Etiología: cardiopatía coronaria e HTA las más frecuentes en Chile; también valvulopatías, miocardiopatías, Chagas, alcohol. Descompensantes: infección, transgresión de sal, mala adherencia, FA, AINE, isquemia.
- Inicial: restricción de sal, furosemida para congestión (20–40 mg/día), IECA/ARA-II y betabloqueador (bisoprolol, carvedilol, metoprolol) iniciados con el paciente euvolémico y titulados.
- En FEVI reducida, terapia cuádruple que reduce mortalidad: sacubitrilo/valsartán o IECA/ARA-II + betabloqueador + espironolactona 25 mg + iSGLT2 (dapagliflozina/empagliflozina 10 mg). Evitar AINE, verapamilo/diltiazem y glitazonas.
- Seguimiento completo: peso diario (consultar si sube >2 kg en 3 días), clase funcional NYHA, PA, FC, potasio y creatinina tras cada ajuste; vacunas influenza y neumococo.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 153

Un paciente de 68 años con antecedentes de infarto de miocardio, hipertensión arterial y tabaquismo se encuentra en tratamiento con aspirina, atorvastatina, enalapril 20 mg cada 12 horas, carvedilol 12,5 mg al día y furosemida 40 mg cada 12 horas. Actualmente presenta disnea de pequeños esfuerzos. Al examen físico tiene FC 65 lpm, PA 110/70 mmHg y saturación de oxígeno de 96 %; se auscultan crépitos pulmonares bibasales y ritmo cardíaco regular en dos tiempos, con un soplo sistólico III/VI. El choque de la punta se palpa en la línea axilar media y presenta edema de extremidades inferiores. **¿Cuál de las siguientes medidas es la más adecuada para este paciente?**

A Agregar losartán
B Agregar hidralazina
C Agregar isosorbide
D Agregar espironolactona
E Agregar amiodarona

Respuesta D. Insuficiencia cardíaca sintomática pese a IECA y betabloqueo: el siguiente fármaco que aumenta la sobrevida es la espironolactona. Losartán no se suma al enalapril: el doble bloqueo del sistema renina-angiotensina aumenta la hiperkalemia y la falla renal sin beneficio.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 135

Un paciente de 71 años, con antecedente de hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia cardíaca, en tratamiento con losartán, metformina, aspirina, nifedipino e hidroclorotiazida consulta por progresión de su disnea de esfuerzos, que aparece al caminar 1 cuadra. Al examen físico, tiene edema de extremidades inferiores, se palpa el choque de la punta en la línea axilar media y se ausculta ritmo cardíaco regular, sin soplos, con crépitos bilaterales en la auscultación pulmonar. Se realiza ecocardiografía que muestra disfunción ventricular, con fracción de eyección de 23%. ¿Qué fármaco debe suspenderse?

A Losartán
B Metformina
C Aspirina
D Nifedipino
E Hidroclorotiazida

Respuesta D. El nifedipino puede agravar una insuficiencia cardíaca, por sus efectos inotrópicos negativos, por lo que en este caso, en que el paciente está descompensado, se debe suspender. Se debería agregar betabloqueo (con cuidado, iniciando dosis bajas) y, por la baja fracción de eyección (menor a 35%), probablemente se agregará espironolactona también, para aumentar la sobrevida (también el betabloqueo).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 10

Un hombre de 66 años, hipertenso e insuficiente cardíaco, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida, consulta por disnea de grandes esfuerzos, asociada a ortopnea de 2 almohadas y escaso edema de extremidades inferiores. Su electrocardiograma tiene signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cuál fármaco es más importante agregar?

A Isosorbide
B Carvedilol
C Losartán
D Furosemida
E Hidroclorotiazida

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Carvedilol (opción B). El betabloqueo aumenta la sobrevida. El losartán también, pero estaba con enalapril.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 1

Mujer de 68 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida (FEVI 35%), clase funcional NYHA III. En tratamiento con furosemida y enalapril. ¿Cuál es el diurético que se debe agregar para mejorar el pronóstico?

A Hidroclorotiazida
B Indapamida
C Clortalidona
D Espironolactona
E Torasemida

Respuesta D. Espironolactona (antagonista de aldosterona) reduce la mortalidad en ICC con FEVI ≤35% y NYHA III-IV (estudio RALES). Se agrega a furosemida + IECA. Monitorizar kalemia y función renal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 93

Un paciente masculino, de 69 años, con antecedente de diabetes e hipertensión arterial, con cardiopatía hipertensiva, en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida y metformina consulta por mayor disnea de la habitual, la que limita sus actividades de la vida diaria, asociada a ortopnea y disnea paroxística nocturna. Al examen físico su PA: 130/80 mmHg, FC: 70x', se observa edema de extremidades inferiores y se auscultan crepitaciones pulmonares escasas, en ambas bases. El examen cardiaco demuestra un choque de la punta en el 5° espacio intercostal, con auscultación normal. Se inicia tratamiento con carvedilol y furosemida, sin mayor respuesta. ¿Qué fármaco es más importante agregar al tratamiento de este paciente?

A Isosorbide
B Hidralazina
C Atorvastatina
D Espironolactona
E Digoxina

Respuesta D. La espironolactona aumenta la sobrevida en la insuficiencia cardíaca (no era necesario un enunciado tan grande para preguntar eso).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 8

Un paciente de 50 años, con antecedente de miocardiopatía dilatada, en tratamiento con enalapril, carvedilol y furosemida, presenta disnea que aparece al realizar esfuerzos moderados, asociado a ortopnea. Su examen físico demuestra desplazamiento del choque de la punta, con crepitaciones de ambas bases pulmonares. Además se solicita una ecocardiografía que muestra una fracción de eyección de 24%. ¿Qué cambio recomendaría a este paciente?

A Reemplazar la furosemida por hidroclorotiazida
B Reemplazar el enalapril por losartán
C Reemplazar el carvedilol por atenolol
D Agregar hidralazina
E Agregar espironolactona

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Agregar espironolactona (opción E). La espironolactona aumenta la sobrevida en la ICC.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 13

Una paciente de 40 años, con antecedente de asma e insuficiencia cardíaca, consulta por aumento de su disnea basal, por lo que se realizan algunos exámenes. Se solicita una ecocardiografía, que muestra cardiomegalia, con paredes finas y una fracción de eyección ventricular de 28%. Además se solicitan exámenes de laboratorio que muestran creatinina: 1,8 mg/dl, Na: 140 mEq/L, K: 3,8 mEq/L, Cl: 106 mEq/L. ¿Qué fármaco está contraindicado en esta paciente?

A Enalapril
B Losartán
C Furosemida
D Espironolactona
E Digoxina

Respuesta E. Con fracción de eyección de 28% los pilares del tratamiento son los IECA o ARA II, el diurético de asa y la espironolactona, que con creatinina de 1,8 y potasio de 3,8 se pueden usar con control. La digoxina es la opción menos adecuada, ya que se elimina por vía renal y se acumula en insuficiencia renal, con riesgo de intoxicación digitálica, y no mejora la mortalidad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 151

Mujer fumadora, hipertensa, con historia de ICC, pero que ahora estaba como desde hace unos 3 meses con disnea de esfuerzo, y al examen pulmonar estaba con sibilancias espiratorias. Preguntaban por la causa del empeoramiento de los síntomas.

A TEP
B Fibrosis pulmonar
C IC
D Cor pulmonale
E Hemograma y VHS

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (IC). Clase sobre el manejo de la hiperpotasemia e hipopotasemia.

▶ VER CLASE `1.01.1.019` **Insuficiencia mitral** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 4.3 · Insuficiencia Mitral Orgánica/Funcional & Prolapso Valvular Mitral (Barlow)

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia mitral: primaria (prolapso, degenerativa, reumática, endocarditis) o secundaria/funcional (dilatación del VI por miocardiopatía o isquemia). Aguda por rotura de cuerdas o músculo papilar post IAM.
- Soplo holosistólico apical irradiado a la axila que aumenta en cuclillas; prolapso mitral: clic mesosistólico + soplo telesistólico que se adelanta con Valsalva o bipedestación.
- Confirmación con ecocardiograma: mecanismo, severidad, FEVI y diámetros; ECG con P mitral o FA.
- Manejo inicial: tratar IC (diuréticos, IECA si FEVI reducida), control de frecuencia y anticoagulación si FA según CHA2DS2-VASc. La IM aguda con EAP es emergencia quirúrgica.

- Indicación quirúrgica en IM primaria severa: síntomas, FEVI ≤60% o diámetro sistólico del VI ≥40 mm; la reparación (plastía) es preferible al reemplazo. GES de cirugía valvular.
- Seguimiento: derivar a cardiología; ecocardiograma periódico según severidad.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 4.3

Mujer de 24 años consulta por palpitaciones ocasionales. Al examen físico se ausculta en el ápex un clic mesosistólico seguido de un soplo telesistólico. ¿Qué ocurre con este soplo al solicitarle a la paciente que se ponga de pie o realice una maniobra de Valsalva?

A El clic y el soplo se adelantan y se vuelven más prolongados
B El soplo desaparece por completo
C El clic se desplaza hacia el segundo ruido y el soplo se acorta
D No se produce ninguna modificación auscultatoria
E Aparece un cuarto ruido cardíaco

Respuesta A. Al realizar la maniobra de Valsalva o ponerse de pie, disminuye el retorno venoso y el volumen del ventrículo izquierdo se reduce. En un ventrículo más pequeño, las valvas mitrales redundantes prolapsan antes durante la eyección sistólica, por lo que el clic se produce más temprano y el soplo se hace más precoz y duradero.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 1

Una paciente de 45 años, con antecedente de enfermedad reumática en la infancia, consulta por un cuadro de 3 meses de evolución de disnea de esfuerzos en capacidad funcional II, que actualmente ha progresado a disnea de mínimos esfuerzos. Al examen físico, su presión arterial es de 120/78 mmHg, su frecuencia cardíaca es de 92 latidos por minuto y su saturación de oxígeno es de 93% a aire ambiental. Se ausculta un soplo holosistólico en el ápex, irradiado a la axila y se palpa el choque de la punta hiperdinámico a la altura del quinto espacio intercostal. El examen pulmonar muestra crepitaciones basales bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Insuficiencia mitral
B Insuficiencia aór2ca
C Estenosis mitral
D Estenosis aór2ca
E Ductus arterioso persistente

Respuesta A. Es una insuficiencia mitral clásica, con clínica de insuficiencia cardiaca izquierda (disnea y crépitos), soplo holosistólico y desplazamiento del choque de la punta, que sugiere cardiomegalia. Revisar resumen de semiología cardiaca.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 38

Un paciente de 70 años, hipertenso, presenta dolor torácico de dos días de evolución, intenso, asociado a malestar general. En las últimas horas se agrega disnea y síncopes ortostáticos. Al examen físico aparece un soplo holosistólico en el ápex. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Taponamiento cardiaco por rotura de la pared libre
B Disección aórtica
C Insuficiencia mitral por rotura del músculo papilar
D Endocarditis bacteriana
E Cardiopatía hipertensiva, descompensada

Respuesta C. Cuadro clásico (tiene soplo ed insuficiencia mitral y la historia de dolor de 2 días: tuvo un IAM hace dos días y ahora se rompió el músculo papilar).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 124

Una paciente presenta un cuadro de 2 días de disnea de esfuerzo, que aparece ante medianos esfuerzos, asociado a tos con expectoración, que en ocasiones es rosada. Al examen físico tiene FC: 94x', PA: 110/70 mmHg, examen pulmonar con crepitaciones bilaterales y examen cardíaco con presencia de un soplo sistólico IV/VI. El diagnóstico más probable es:

A Tromboembolismo pulmonar
B Insuficiencia tricuspídea
C Neumopatía aguda
D Insuficiencia mitral aguda
E Disección aórtica

Respuesta D. El soplo sistólico y los síntomas de ICC izquierda hacen sospechar la insuficiencia mitral. La expectoración rosada suele ser más de estenosis mitral, pero sí se puede ver en la insuficiencia mitra. Ver resumen de semiología cardíaca.

▶ VER CLASE 1.01.1.020 Miocardiopatías

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Cardiología 3.5 · Miocardiopatías (Hipertrófica, Dilatada, Restrictiva & Miocarditis)
Infectología 4.2 · Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Miocardiopatía dilatada: dilatación y FEVI reducida; causas idiopática/genética, alcohol, Chagas (relevante en Chile), miocarditis previa, quimioterapia (antraciclinas), periparto, taquicardiomiopatía.

- Miocardiopatía hipertrófica: hipertrofia septal asimétrica (≥15 mm), soplo sistólico que AUMENTA con Valsalva y bipedestación y disminuye en cuclillas; principal causa de muerte súbita en atletas jóvenes.
- Restrictiva: amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis; IC con FEVI preservada, aurículas grandes y ECG de bajo voltaje. Sospechar Chagas ante BCRD + hemibloqueo anterior izquierdo en zona endémica.
- Sospecha por IC, síncope de esfuerzo, arritmias o soplo en joven; confirmar con ecocardiograma; ECG anormal en la gran mayoría.
- Manejo inicial: dilatada como IC con FEVI reducida (terapia cuádruple); hipertrófica con betabloqueador o verapamilo, evitando nitratos, diuréticos en exceso y digoxina; abstinencia de alcohol.
- Seguimiento: derivar a cardiología para estudio etiológico, estratificación de muerte súbita (DAI) y tamizaje familiar en formas genéticas.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 28

Una paciente de 14 años presenta caída al suelo, con inconsciencia de 30 segundos, recuperándose luego por completo. **¿Cuál de los siguientes antecedentes orientan a una causa cardiogénica del cuadro?**

A Ausencia de episodios anteriores

B Relación con la micción

C Relación con el ejercicio

D Relación con la tos

E Ocurrencia al incorporarse desde la posición acostada

Respuesta C. El síncope durante el ejercicio, o en reposo sin gatillante ni pródromos, sugiere causa cardiogénica. La micción y la tos se asocian a síncopes situacionales (reflejos); el incorporarse, a síncope ortostático.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 41

Hombre de 40 años consulta por un síncope mientras jugaba fútbol, con recuperación completa. Además refiere disnea de esfuerzos que se inició hace 3 meses y ha aumentado lentamente. Su hermano murió súbitamente a los 25 años. Al examen físico se constata un soplo sistólico eyectivo, sin otras alteraciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Tromboembolismo pulmonar

B Síndrome de Brugada

C Miocardiopatía hipertrófica

D Síncope disautonómico

E Síndrome de QT largo

Respuesta C. Síncope de esfuerzo, disnea, soplo sistólico eyectivo y un hermano con muerte súbita joven es la miocardiopatía hipertrófica clásica, principal causa de muerte súbita en deportistas jóvenes. Se confirma con ecocardiograma. El Brugada y el QT largo dan síncope y muerte súbita familiar, pero no un soplo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 54

Un paciente de 31 años presenta un cuadro de disnea de esfuerzos, ortopnea y astenia. Su presión arterial es 120/70 mmHg y su pulso es de 80x', además presenta edema en las EEII. Presenta desplazamiento del choque de la punta, a dos centímetros de la línea medio-clavicular y se ausculta galope cardiaco, con un soplo sistólico en el ápex, que no varía con la inspiración. Al examen pulmonar tiene crepitos basales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Miocardiopatía hipertrófica

B Miocardiopatía dilatada

C Insuficiencia aórtica

D Estenosis aórtica

E Estenosis mitral

Respuesta B. Miocardiopatía dilatada clásica. El soplo que tiene es por insuficiencia mitral, por dilatación del anillo valvular. No aparece insuficiencia mitral en las alternativas (e igual es más probable que sea un MCP dilatada)

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 179

Paciente de 17 años, sin antecedentes, es traído a la urgencia por presentar síncope mientras realizaba ejercicio, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia soplo sistólico que aumenta con maniobras de vansalva, sin otros hallazgos. Se estudia con electrocardiograma que muestra onda Q presente en DII, DIII y AVF, además S profunda de V1 a V3. El diagnóstico más probable es:

A Miocardiopatía dilatada

B Lipotimia

C Soplo fisiológico

D Miocardiopatía hipertrófica

E Estenosis mitral

Respuesta D. Debe decir S profunda. Clínica sí es de MCPHT. Viene con signos de HTVI: S profunda en V1 y V2, R alta en V5, V6. Además tiene ondas T gigantes e invertidas en las precordiales.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 3

Una paciente de 35 años, primípara, está en su cuarto día postparto vaginal. Su embarazo fue adecuadamente controlado, siendo normal durante toda la gestación. Consulta por un cuadro de disnea que ha aumentado significativamente en los últimos días, siendo actualmente de reposo. Al examen físico presenta frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto y presión arterial de 110/60 mmHg, con auscultación cardíaca que muestra un ritmo de galope por presencia de R3 y examen pulmonar que demuestra la presencia de crépitos basales bilaterales. Satura 94% a FiO2 ambiental y se observa edema de extremidades inferiores fóvea ++. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Edema pulmonar no cardiogénico
B Miocardiopatía periparto
C Tromboembolismo pulmonar
D Embolia de líquido amniótico
E Neumonía

Respuesta B. Miocardiopatía periparto: El cuadro clínico sugiere insuficiencia cardíaca congestiva con disfunción sistólica (tercer ruido). La desaturación y las crepitaciones pulmonares sugieren un edema pulmonar cardiogénico. El contexto de la paciente puérpera obliga a pensar en una miocardiopatía periparto. Si no hubiese estado embarazada, sería miocardiopatía dilatada. El tromboembolismo pulmonar presentaría un inicio súbito.

▶ VER CLASE 1.01.1.021 Paciente con soplo

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 4.4 · Semiología de Soplos, Maniobras Dinámicas & Cardiopatías Congénitas del Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Caracterizar el soplo: momento del ciclo, foco, irradiación, intensidad (I–VI; ≥III/VI o con frémito es patológico) y respuesta a maniobras.
- Soplo inocente: sistólico eyectivo, suave (≤II/VI), sin frémito, varía con la posición, sin síntomas ni otros hallazgos; frecuente en niños, embarazo, fiebre y anemia.
- Patológico siempre: todo soplo diastólico, holosistólico, continuo o con síntomas, cardiomegalia, ECG alterado o S2 anormal.
- Maniobras: inspiración aumenta los soplos derechos (Rivero-Carvallo); Valsalva y bipedestación aumentan solo MCH y prolapso mitral; cuclillas y empuñadura aumentan la mayoría (IM, IAo, CIV).
- Principales: EAo (mesosistólico aórtico a carótidas), IM (holosistólico apical a axila), IAo (diastólico aspirativo), EM (retumbo diastólico apical), CIV (holosistólico paraesternal rudo).
- Estudio con ecocardiograma y seguimiento: derivar a cardiología todo soplo patológico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 4.4

Mujer de 28 años asintomática. Al examen físico destaca un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco que no varía con la respiración y un soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar. El ECG muestra bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Comunicación interauricular (CIA tipo ostium secundum)
B Estenosis aórtica severa
C Comunicación interventricular restrictiva
D Ductus arterioso persistente
E Tetralogía de Fallot corregida

Respuesta A. El desdoblamiento amplio y FIJO del segundo ruido (que no cambia de intervalo durante la inspiración ni espiración) asociado a un soplo de hiperflujo pulmonar y bloqueo de rama derecha es el hallazgo patognomónico de la Comunicación Interauricular (CIA).

▶ VER CLASE 1.01.1.022 Pericarditis aguda

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 5.3 · Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco

QUÉ HAY QUE SABER

- Pericarditis aguda: dolor torácico punzante que aumenta con la inspiración y el decúbito y alivia al inclinarse hacia adelante; frote pericárdico. Causa viral/idiopática la más frecuente.
- Diagnóstico con ≥2 de 4: dolor típico, frote, ECG con supradesnivel ST cóncavo difuso + infradesnivel del PR, derrame pericárdico nuevo. Solicitar ECG, PCR, troponina (miopericarditis) y ecocardiograma.
- Tratamiento: ibuprofeno 600 mg c/8 h o aspirina 750–1000 mg c/8 h por 1–2 semanas con descenso + colchicina 0,5 mg c/12 h (0,5 mg/día si <70 kg) por 3 meses; reposo deportivo.
- Evitar corticoides como primera línea (aumentan recurrencias). Signos de alto riesgo para hospitalizar: fiebre >38 °C, derrame severo, taponamiento, inmunosupresión, troponina elevada, falta de respuesta a AINE.
- Taponamiento (hipotensión, ingurgitación yugular, ruidos apagados, pulso paradójico) es emergencia: pericardiocentesis.
- Seguimiento: la pericarditis no complicada no requiere seguimiento especializado; control clínico de respuesta y consultar si recurre.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 5.3

Hombre de 26 años con pericarditis aguda viral. ¿Cuál es la terapia farmacológica de primera línea recomendada para tratar el episodio actual y reducir significativamente la tasa de recidiva a largo plazo?

A Antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) asociados a Colchicina durante 3 meses

B Prednisona en dosis altas en monoterapia

C Antibioticoterapia empírica con Ceftriaxona endovenosa

D Anticoagulación con Heparina de bajo peso molecular

E Paracetamol 500 mg cada 12 horas SOS

Respuesta A. Las guías internacionales de la ESC y consensos clínicos establecen que el tratamiento estándar de primera línea de la pericarditis aguda es la asociación de AINEs (Ibuprofeno o Aspirina en dosis altas) con Colchicina durante 3 meses, debido a que la adición de colchicina disminuye a la mitad la tasa de recurrencias y recidivas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 94

Un paciente de 40 años, con antecedente de reflujo gastroesofágico, consulta por dolor torácico de algunas horas de evolución, tipo puntada, muy intenso. Refiere que el dolor no respondió al uso de omeprazol. En su examen físico se aprecia adolorido, con FC: 76x', PA: 110/70 mmHg, ritmo regular en 2 tonos, sin soplos. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra a continuación: Foto 8 (https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=86115). El diagnóstico más probable es:

A Pericarditis aguda

B Espasmo esofágico

C Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared lateral

D Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared inferior

E Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared inferolateral

Respuesta A. Es una pericarditis clásica, tanto por la clínica, como por el EKG con SDST en J en casi todas las derivaciones.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 81

Un hombre de 31 años, deportista, consulta por dolor precordial de 2 días de evolución, EVA 8/10, asociado a leve sensación de ahogo, que aparece especialmente al recostarse. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A Infarto agudo al miocardio

B Pericarditis aguda

C Neumotórax espontáneo

D Tromboembolismo pulmonar

E Costocondritis del deportista

Respuesta B. Es una pericarditis clásica, tanto por la edad y la clínica (aumenta al acostarse) como por el EKG con SDST en J casi todas las derivaciones. También tiene depresión del PR en algunas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 59

Un paciente de 30 años, deportista, pregunta por dolor precordial opresivo, de dos días de evolución, irradiado al cuello y al hombro izquierdo, intenso. Además presenta disnea que aumenta al recostarse. Al examen físico está adolorido, con RR2T sin soplos. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A Tromboembolismo pulmonar

B Neumotórax

C Pericarditis aguda

D Miocardiopatía hipertrófica

E Costocondritis del deportista

Respuesta C. Dolor precordial opresivo que mejora al inclinarse y empeora al recostarse, en un joven, con depresión del segmento PR en el ECG, corresponde a pericarditis aguda. El TEP, el neumotórax y la costocondritis no explican el ECG, y la miocardiopatía hipertrófica no produce este cuadro doloroso agudo con esas alteraciones.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 139

Paciente con dolor torácico retroesternal, antecedente de RGE, en buenas condiciones. ECG con elevación difusa del ST en silla de montar. ¿Diagnóstico más probable?

A SCA con elevación del ST (SCACEST)

B Angina inestable

C Miocarditis aguda viral

D Pericarditis aguda

E Espasmo coronario (angina de Prinzmetal)

Respuesta D. Diagnóstico: Pericarditis aguda (opción D). Pericarditis aguda. Las enfermedades del pericardio incluyen pericarditis aguda, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 29

Un paciente de 40 años consulta por dolor retroesternal opresivo, irradiado al dorso, que inició después de comer y que tiene una intensidad de 8/10, con tope inspiratorio. Al examen físico tiene FC: 100x, PA: 130/88 mmHg, T°: 37,7°C, examen pulmonar normal, auscultación cardíaca con ritmo regular en dos tonos, sin soplos. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: www.cardioscience.com.mx): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Tromboembolismo pulmonar
B Pericarditis aguda
C Disección aórtica
D Infarto agudo al miocardio de pared inferior
E Infarto agudo al miocardio de pared anterolateral

Respuesta B. Diagnóstico: Pericarditis aguda (opción B). Las enfermedades del pericardio incluyen pericarditis aguda, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva.

▶ VER CLASE 1.01.1.023 Síndrome metabólico

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.6 · Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome metabólico (ATP III armonizado): ≥3 de 5: circunferencia de cintura ≥90 cm hombres/≥80 cm mujeres (corte chileno), TG ≥150 mg/dL, HDL <40 (H)/<50 (M), PA ≥130/85 o tratamiento, glicemia en ayunas ≥100 mg/dL.
- Base fisiopatológica: obesidad abdominal e insulinorresistencia (acantosis nigricans); aumenta el riesgo de DM2, enfermedad cardiovascular e hígado graso.
- Estudio: peso, IMC, cintura, PA, glicemia (PTGO si glicemia 100–125), perfil lipídico, transaminasas; estimar riesgo cardiovascular global.
- Tratamiento de elección: cambio de estilo de vida, con baja de peso de 5–10%, dieta mediterránea/hipocalórica y actividad física ≥150 min/semana; cesación tabáquica.
- Tratar cada componente según metas: estatina por riesgo CV, antihipertensivos, metformina en prediabetes de alto riesgo; considerar fármacos antiobesidad o cirugía bariátrica en obesidad severa.
- Seguimiento completo en APS (Programa de Salud Cardiovascular / Vida Sana): control de peso, cintura y laboratorio periódico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 48 años asiste a control de salud. Tiene circunferencia de cintura de 106 cm, presión arterial 136/86 mmHg, glicemia de ayuno 108 mg/dL, triglicéridos 190 mg/dL y colesterol HDL 36 mg/dL. No usa fármacos. **¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?**

A Diabetes mellitus tipo 2
B Síndrome metabólico
C Hipertensión arterial etapa 1
D Hipercolesterolemia familiar
E Síndrome de Cushing

Respuesta B. Cumple los 5 criterios de síndrome metabólico (bastan 3): obesidad abdominal, PA ≥130/85 mmHg, glicemia de ayuno ≥100 mg/dL, triglicéridos ≥150 mg/dL y HDL bajo 40 mg/dL en hombres. No tiene diabetes (ayuno bajo 126) ni hipertensión (bajo 140/90). Implica alto riesgo cardiovascular.

▶ VER CLASE 1.01.1.024 Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 1.4 · TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White

QUÉ HAY QUE SABER

- TPSV: taquicardia regular de QRS estrecho a 150–250 lpm, inicio y término súbitos; reentrada nodal la más frecuente (mujeres jóvenes), seguida de vía accesoria (WPW).
- ECG en crisis: ondas P ausentes o retrógradas (pseudo-r' en V1). En ritmo sinusal, WPW: PR corto <120 ms + onda delta + QRS ancho.
- Inestable (hipotensión, dolor, IC, compromiso de conciencia): cardioversión eléctrica sincronizada.
- Estable: maniobras vagales (Valsalva modificada, masaje carotídeo si sin soplos) → adenosina 6 mg EV en bolo rápido, 12 mg si no responde; alternativa verapamilo 5 mg EV o betabloqueador.
- En FA preexcitada (WPW, QRS ancho irregular) están contraindicados adenosina, verapamilo, digoxina y betabloqueadores: usar procainamida o cardioversión.
- Seguimiento completo: enseñar maniobras vagales, betabloqueador o verapamilo profiláctico si crisis frecuentes; derivar a electrofisiología para ablación (curativa) si recurrente o WPW.

PREGUNTAS · 9

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 1.4

Hombre de 26 años con palpitaciones paroxísticas regulares de inicio súbito a 180 lpm y QRS estrecho. Se realizaron maniobras vagales sin éxito. ¿Cuál es el fármaco de primera línea y la técnica correcta de administración?

A Adenosina 6 mg en bolo endovenoso ultrarrápido seguido de bolo de 20 mL de suero fisiológico

B Amiodarona 300 mg en infusión continua para 1 hora

C Verapamilo 10 mg por vía intramuscular profunda

D Digoxina 0.5 mg en infusión lenta

E Lidocaína 100 mg endovenosa

Respuesta A. La Adenosina tiene una vida media ultracorta (< 10 segundos). Para que alcance concentraciones terapéuticas en el nodo AV, debe inyectarse en bolo ultrarrápido (1-2 segundos) en una vena periférica proximal, seguido de un bolo de lavado de 20 mL de solución fisiológica y elevación del brazo. La dosis inicial es de 6 mg.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 3

Un paciente de 28 años consulta por dolor torácico y disnea de 2 horas de evolución. Al examen físico presenta taquicardia a 170 lpm, presión arterial 120/80 mmHg y un examen cardiopulmonar con ritmo regular en dos tonos, sin soplos, en la auscultación cardíaca y murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados, en la auscultación pulmonar. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a continuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Verapamilo endovenoso

B Amiodarona endovenosa

C Adrenalina endovenosa

D Adenosina endovenosa

E Cardioversión eléctrica

Respuesta D. Tiene una TPSV clásica. El tratamiento de primera línea son las maniobras vagales (ej. Valsalva modificado es la más recomendada en adultos y niños que cooperan; en niños pequeño se prefiere la inmersión facial en agua fría. El masaje carotídeo se puede usar en adultos, pero no se recomienda en niños ni en adultos mayores con riesgo de ateroma carotídeo que se pueda soltar). De segunda línea se utilizan fármacos, siendo de elección la adenosina en bolo EV de 6 mg. Si falla, se dan hasta dos...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 134

Mujer de 25 años con palpitaciones paroxísticas. ECG en sinusal muestra intervalo PR corto y onda delta. Episodio de TPSV con QRS ancho. ¿Cuál es el diagnóstico?

A Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)

B Fibrilación auricular

C Taquicardia ventricular

D Bloqueo AV completo

E Síndrome de QT largo

Respuesta A. PR corto + onda delta + TPSV con QRS ancho = síndrome de WPW (preexcitación ventricular por vía accesoria). La taquicardia puede ser ortodrómica (QRS estrecho) o antidrómica (QRS ancho).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 87

Un paciente de 22 años consulta por palpitaciones de inicio súbito, rápidas y molestas, que duraron cerca de 30 minutos y desaparecieron con maniobras vagales. Refiere que había presentado episodios previos, pero de menor duración y autolimitados. Actualmente está en buenas condiciones y al examen físico, no presenta alteraciones. Trae un electrocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: cardioteca.com): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Fibrilación auricular

B Síndrome de Wolff Parkinson White

C Bloqueo completo de rama izquierda

D Flutter auricular

E Síndrome de Brugada

Respuesta C. Diagnóstico: Bloqueo completo de rama izquierda (opción C). La taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) es una taquicardia regular de complejos angostos con inicio y término súbitos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 44

Joven de 22 años con palpitaciones súbitas de inicio y término brusco. ECG en crisis: taquicardia regular de QRS estrecho a 180 lpm. Cede con maniobra de Valsalva. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección si reaparece?

A Adenosina IV en bolo rápido

B Amiodarona EV

C Metoprolol oral

D Digoxina IV

E Cardioversión eléctrica sincronizada

Respuesta A. TPSV (taquicardia paroxística supraventricular) estable: si maniobras vagales fallan, adenosina IV 6 mg en bolo rápido es el tratamiento de elección por su efecto ultrabreve sobre el nodo AV.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 141

Paciente con palpitaciones regulares y taquicardia supraventricular en el ECG. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A Verapamilo 5 mg EV lento
B Amiodarona 300 mg EV
C Cardioversión eléctrica sincronizada
D Metoprolol 5 mg EV
E Adenosina 6 mg IV en bolo rápido

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Adenosina 6 mg IV en bolo rápido (opción E). Adenosina 6 mg IV en bolo rápido.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 69

Un paciente de 10 años, es traído por cuadro de inicio agudo de dos horas de evolución caracterizados por palpitaciones y dolor torácico. Al ingreso se conecta a monitor que muestra frecuencia cardiaca de 200 latidos por minutos, regular y QRS angosto. La primera medida para el manejo en este caso es:

A Realizar presión orcular
B Realizar cardioversión eléctrica
C Administrar adenosina endovenosa
D Realizar masaje carotídeo
E Administrar verapamilo endovenoso

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar masaje carotídeo (opción D). Tiene una TPSV y lo primero son las maniobras vagales, luego la adenosina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 59

Un paciente de 28 años consulta por un cuadro de 3 horas de evolución de palpitaciones intensas, asociadas a disnea. Al examen físico, tiene FC: 160 por minuto, regular, PA: 110/70 mmHg, examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos, sin soplos y murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación: ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A Amiodarona 150 mg endovenosa
B Lidocaína 100 mg endovenosa
C Adenosina 6mg intravenosa
D Diltiazem 25 mg endovenoso
E cardioversión eléctrica

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Adenosina 6mg intravenosa (opción C).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 31

Mujer con síntomas ansiosos y EKG (taquicardia regular QRS estrecho aprox 150 lpm): a. Adenosina

A Insuficiencia cardíaca
B Fibrilación auricular
C Infarto agudo al miocardio
D Tromboembolismo pulmonar
E Pericarditis aguda

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Insuficiencia cardíaca). La taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) es una taquicardia regular de complejos angostos con inicio y término súbitos.

Situaciones clínicas de urgencia

9 códigos

▶ VER CLASE `1.01.2.001` **Angina inestable** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 2.2 · SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST

QUÉ HAY QUE SABER

- Angina inestable: angina de reposo (>20 min), de reciente comienzo (<2 meses, CCS ≥III) o en crescendo; SCA sin supradesnivel ST con troponinas NORMALES (si se elevan es IAM sin SDST).
- ECG en <10 minutos: puede ser normal o con infradesnivel ST o inversión de T; repetir ECG seriado y troponinas ultrasensibles a las 0 y 1–3 h.
- Manejo inicial: aspirina 250–500 mg masticada, segundo antiagregante (ticagrelor 180 mg o clopidogrel 300–600 mg), enoxaparina 1 mg/kg c/12 h SC, atorvastatina 80 mg, nitroglicerina SL/EV si dolor, O2 solo si SatO2 <90%.
- Betabloqueador oral si no hay IC, bradicardia ni shock; morfina solo si dolor refractario. La trombolisis está CONTRAINDICADA en SCA sin supradesnivel.
- Estratificar riesgo (TIMI, GRACE): alto riesgo (dolor persistente, inestabilidad hemodinámica, arritmias, cambios dinámicos del ST) → coronariografía precoz (<24 h, inmediata si muy alto riesgo).
- Seguimiento: derivar a cardiología para estudio coronario y revascularización; GES de IAM/SCA.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 2.2

¿Cuál de los siguientes pacientes con SCASEST tiene indicación de coronariografía invasiva urgente en MENOS de 2 horas?

A Paciente con dolor torácico persistente refractario al tratamiento médico e inestabilidad hemodinámica

B Paciente de 60 años asintomático tras recibir nitroglicerina con TIMI de 2 puntos

C Paciente con dolor torácico autolimitado y troponinas negativas

D Paciente hipertenso con ECG normal y dolor atípico

E Paciente con Score GRACE de 110 puntos sin nuevos episodios de dolor

Respuesta A. La coronariografía inmediata (< 2 horas) se reserva para pacientes con criterios de muy alto riesgo isquémico o inestabilidad: shock cardiogénico, inestabilidad hemodinámica, dolor torácico refractario a nitratos/analgesia, arritmias ventriculares malignas o insuficiencia cardíaca aguda secundaria a isquemia.

▶ VER CLASE 1.01.2.002 Disección aórtica

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 5.4 · Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante dolor torácico o dorsal súbito, intenso, desgarrante y migratorio, en hipertenso, Marfan, válvula bicúspide o consumo de cocaína.
- Signos: asimetría de pulsos o PA >20 mmHg entre brazos, soplo de insuficiencia aórtica nuevo, déficit neurológico, isquemia de extremidades o mesentérica; Rx con ensanchamiento mediastínico.
- Confirmación: angioTAC de aorta (examen de elección); ecocardiograma transesofágico si inestable. No anticoagular ni trombolizar ante la sospecha (diferencial con IAM).
- Tratamiento inicial: analgesia con opioides, control de FC <60 lpm y PAS 100–120 mmHg con betabloqueador EV (labetalol o esmolol) ANTES de vasodilatadores (nitroprusiato).
- Stanford A (aorta ascendente): cirugía de urgencia. Stanford B (descendente): manejo médico en UCI, endoprótesis si complicada.
- Seguimiento: derivar de inmediato a cirugía cardiovascular/UCI.

PREGUNTAS · 11

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 5.4

Hombre de 59 años hipertenso ingresa con dolor torácico retroesternal transfixiante hacia la espalda. AngioTAC confirma Disección Aórtica que compromete la aorta ascendente extendiéndose hasta el arco aórtico (Stanford A). ¿Cuál es el tratamiento definitivo de elección?

A Cirugía cardíaca de reemplazo aórtico de urgencia inmediata

B Manejo médico conservador exclusivo en UCI con Betabloqueadores

C Fibrinólisis endovenosa con Tenecteplase

D Implante de Stent aórtico percutáneo electivo en 1 mes

E Anticoagulación con Heparina no fraccionada en infusión

Respuesta A. Toda Disección Aórtica Stanford A (que compromete la aorta ascendente) es una emergencia quirúrgica absoluta que exige resolución quirúrgica inmediata a tórax abierto para reemplazar el segmento disecado y evitar la muerte por rotura intrapericárdica, taponamiento o infarto masivo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 98

Un paciente de 69 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, consulta por dolor torácico intenso EVA 10/10, de carácter lancinante y que se irradia a cuello y dorso. A lo anterior se agregó dolor intenso en la extremidad superior izquierda. Al examen físico tiene FC: 120x', PA: 200/140 mmHg, ritmo regular en dos tiempos, sin soplos, murmullo pulmonar bilateral conservado, sin otros ruidos, extremidad superior izquierda con disminución del pulso radial y frialdad de la mano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Pericarditis aguda

B Disección aórtica

C Tromboembolismo pulmonar

D Infarto agudo al miocardio

E Embolias cardíacas

Respuesta B. Diagnóstico: Disección aórtica (opción B). La combinación cardinal de dolor torácico súbito desgarrador (EVA 10/10) irradiado a región interescapular o dorso, cifras tensionales severas y asimetría de pulsos periféricos en extremidades superiores es patognomónica de disección aórtica aguda. Requiere angio-TAC de tórax inmediato y estabilización hemodinámica con betabloqueadores EV para reducir la fuerza de eyección ventricular (dP/dt).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 22

Paciente masculino de 55 años con dolor torácico desgarrador de inicio súbito, irradiado a la espalda. TA en brazo derecho 185/100 y en brazo izquierdo 140/80. TC: disección de aorta tipo B de Stanford. ¿Cuál es el manejo inicial?

A Manejo médico: control de frecuencia cardíaca y presión arterial

B Cirugía de emergencia

C Trombólisis sistémica

D Endoprótesis aórtica de urgencia

E Anticoagulación con heparina EV

Respuesta A. Disección aórtica tipo B de Stanford (no compromete aorta ascendente): manejo médico con betabloqueadores para reducir FC <60 lpm y PA sistólica 100-120 mmHg. Cirugía solo si hay complicaciones.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 157

Paciente con dolor torácico EVA 10/10 retroesternal con irradiación a dorso, pulso radial izquierdo débil y llene capilar enlentecido. ¿Diagnóstico más probable?

A SCA con elevación del ST

B Tromboembolismo pulmonar masivo

C Disección aórtica

D Rotura esofágica (Boerhaave)

E Neumotórax a tensión

Respuesta C. Diagnóstico: Disección aórtica (opción C). Disección aórtica. La combinación cardinal de dolor torácico súbito desgarrador (EVA 10/10) irradiado a región interescapular o dorso, cifras tensionales severas y asimetría de pulsos periféricos en extremidades superiores es patognomónica de disección aórtica aguda. Requiere angio-TAC de tórax inmediato y estabilización hemodinámica con betabloqueadores EV para reducir la fuerza de eyección ventricular (dP/dt).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 12

Un paciente de 70 años, con antecedente de hipertensión, en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida, consulta por dolor torácico, EVA 9/10, irradiado a dorso, asociado a malestar general y sudoración. Al examen físico tiene FC: 110x', PA: 170/110 mmHg, examen pulmonar con crépitos escasos bibasales y examen cardíaco con choque de la punta no desplazado y auscultación con ritmo regular, en dos tiempos, con presencia de un soplo cardíaco diastólico aspirativo, de intensidad IV/VI, de ubicación paraesternal derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Neumotórax

B Aneurisma de la aorta ascendente

C Infarto miocárdico con rotura del músculo papilar

D Tromboembolismo pulmonar

E Disección aórtica tipo A

Respuesta E. Es una clásica disección aórtica, con el soplo diastólico de la insuficiencia aórtica (se diseca la válvula). Es tipo A, porque, al afectar la válvula, obviamente está sobre la subclavia izquierda.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 16

Paciente de 50 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento irregular con hidroclorotiazida, consulta por dolor torácico de 30 minutos de duración, transfixiante, irradiado a epigastrio, asociado a mareos y diaforesis. Al examen se aprecia pálido, sudoroso, PA 150/90, FC: 110x', saturación de oxígeno de 93% con FiO2 ambiental, ritmo regular, asociado a soplo diastólico II/ VI y disminución del segundo ruido, abdomen blando, depresible e indoloro, ruidos hidroaéreos presentes. Al ingreso se solicita ECG que muestra alteraciones inespecíficas en pared anterolateral, además troponinas que están con resultado pendiente. El diagnóstico más probable es:

A Disección aórtica

B Infarto agudo al miocardio sin supradesnivel de ST

C Tromboembolismo pulmonar

D Infarto mesentérico

E Pancreatitis aguda

Respuesta A. Disección aórtica por el soplo diastólico. La disminución del R2 y el soplo son por la insuficiencia Aórtica

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 144

Un paciente de 63 años, con antecedente de hipertensión y dislipidemia, en tratamiento con losartán, hidroclorotiazida y atorvastatina consulta en el servicio de urgencia por dolor torácico intenso, EVA 9/10, irradiado al dorso. Al examen físico está diaforético y angustiado, con FC: 115x', PA: 220/117 mmHg, examen pulmonar con crépitos escasos bibasales y examen cardíaco con choque de la punta no desplazado y auscultación con ritmo regular, en dos tiempos con ruidos apagados. Se solicita un electrocardiograma que muestra taquicardia sinusal y troponinas plasmáticas, que resultan negativas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Neumotórax

B Infarto agudo al miocardio

C Taponamiento pericárdico

D Tromboembolismo pulmonar

E Disección aórtica

Respuesta E. Orientan a disección aórtica la irradiación al dorso, la concomitancia con una crisis hipertensiva, el EKG sin signos de isquemia y las troponinas normales, que hacen menos probable un infarto. Se debe estudiar con angioTAC de tórax. Se maneja con drogas antiHTA por vía endovenosa y con cirugía, si es tipo A (sobre subclavia).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 143

Un paciente de 65 años, hipertenso de larga data, mal controlado, consulta por dolor torácico intenso, EVA 8/10, transfixiante. Al examen físico se observa angustiado y sudoroso, con FC: 115x' PA: 160/110 mmHg, murmullo pulonar presente, simétrico y examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos, con auscultación de un soplo diastólico III/VI en el precordio. Se solicita un electrocardiograma que muestra una taquicardia sinusal y las enzimas cardíacas resultan negativas. El diagnóstico más probable es:

A Neumotórax
B Espasmo esofágico
C Infarto agudo al miocardio
D Síndrome aórtico agudo
E Tromboembolismo pulmonar

Respuesta D. Es una disección aórtica clásica, debido al soplo diastólico de la insuficiencia aórtica. Se debe estudiar con angioTAC y, en este caso, por ser probablemente tipo A, se debe operar (ya que está afectando la válvula aórtica y, por ello, se puede asumir que disecó sobre la subclavia izquierda).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 12

Un paciente de 75 años, diabético e hipertenso, consulta por dolor torácico intenso, de inicio súbito, que alcanza un EVA 7/10, de 2 horas de evolución. El dolor tenía una localización retroesternal, pero luego migra a la zona dorsolumbar. Al examen físico destaca disminución de los pulsos de las extremidades inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Infarto agudo al miocardio
B Aneurisma de la aorta abdominal complicado
C Tromboembolismo pulmonar masivo
D Disección aórtica
E Neumotórax

Respuesta D. Diagnóstico: Disección aórtica (opción D). Es una disección clásica por la asimetría de pulsos. La combinación cardinal de dolor torácico súbito desgarrador (EVA 10/10) irradiado a región interescapular o dorso, cifras tensionales severas y asimetría de pulsos periféricos en extremidades superiores es patognomónica de disección aórtica aguda. Requiere angio-TAC de tórax inmediato y estabilización hemodinámica con betabloqueadores EV para reducir la fuerza de eyección ventricular (dP/dt).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 37

Un paciente de 67 años, diabético, hipertenso, presenta dolor torácico intenso, irradiado al dorso, EVA 9/10. Al examen físico está taquicárdico, con presión arterial es de 160/110, examen cardiaco con RR2T y se ausculta un soplo diastólico en el reborde esternal derecho. El diagnóstico más probable es:

A Tromboembolismo pulmonar
B Pericarditis aguda
C Infarto agudo al miocárdico con rotura de la pared libre
D Infarto agudo al miocárdico con rotura del tabique interventricular
E Disección aórtica

Respuesta E. Diagnóstico: Disección aórtica (opción E). El soplo diastólico (rotura de la válvula aórtica) y la HTA orientan a disección. La combinación cardinal de dolor torácico súbito desgarrador (EVA 10/10) irradiado a región interescapular o dorso, cifras tensionales severas y asimetría de pulsos periféricos en extremidades superiores es patognomónica de disección aórtica aguda. Requiere angio-TAC de tórax inmediato y estabilización hemodinámica con betabloqueadores EV para reducir la fuerza de...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 180

Un paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial e hipotiroidismo, en tratamiento con enalapril y levotiroxina, consulta por dolor torácico intenso, que inició hace 22 horas, inicialmente con EVA 9/10, que se irradiaba al dorso y posteriormente al abdomen. Tomó analgésicos y el dolor disminuyó de intensidad, sin embargo, persiste 5/10, por lo que decidió consultar. Al examen físico, tiene FC: 98x', PA: 170/112 mmHg, pulsos de extremidades superiores conservados y disminución de los pulsos de las extremidades inferiores; examen cardíaco muestra ritmo regular en dos tiempos, sin soplos y examen pulmonar con murmullo vesicular presenta y simétrico, sin ruidos agregados. Se solicita electrocardiograma que muestra una taquicardia sinusal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

A Ecocardiograma transtorácico
B Angiografía coronaria
C AngioTAC de tórax y abdomen
D Radiografía de tórax
E Troponinas plasmáticas

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: AngioTAC de tórax y abdomen (opción C). Es el método diagnóstico de elección debido a su alta sensibilidad (>95%) y capacidad para evaluar complicaciones y extensión anatómica con precisión milimétrica antes de decidir la terapéutica invasiva.

▶ VER CLASE 1.01.2.003 **Embolia cardiogénica** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.2 · Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Embolía de origen cardíaco: ACV o AIT, isquemia aguda de extremidad, mesentérica o renal. Fuentes: FA (la más frecuente), trombo intraventricular post IAM, valvulopatía mitral, prótesis, endocarditis, mixoma, foramen oval permeable.

- Isquemia aguda de extremidad: dolor, palidez, ausencia de pulsos, parestesias, parálisis y frialdad (6P); sin historia de claudicación sugiere embolía.
- ACV cardioembólico: déficit de inicio súbito y máximo desde el comienzo, a veces múltiples territorios; TAC/RM, ECG y Holter para buscar FA, ecocardiograma.
- Manejo inicial: ACV → código ACV, trombolisis/trombectomía según ventana; isquemia de extremidad → heparina no fraccionada EV (bolo 80 U/kg) y derivar a cirugía vascular para embolectomía.
- Prevención secundaria: anticoagulación oral en FA (DOAC; en ACV se inicia habitualmente entre días 1 y 14 según tamaño del infarto); en endocarditis NO anticoagular.
- Seguimiento: derivar a neurología, cirugía vascular o cardiología según el territorio comprometido.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 74 años, hipertensa, presenta afasia y hemiparesia derecha de inicio súbito. Al examen tiene pulso irregular de 110 por minuto. El ECG muestra fibrilación auricular, que desconocía. La TAC de encéfalo no muestra hemorragia y la RM confirma un infarto cortical en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. **Una vez superada la fase aguda, ¿cuál es la medida más eficaz para prevenir un nuevo evento?**

A Aspirina 100 mg/día

B Clopidogrel más aspirina por 1 año

C Anticoagulación oral

D Endarterectomía carotídea

E Control de frecuencia con atenolol solamente

Respuesta C. Un infarto cortical con fibrilación auricular es una embolia cardiogénica. La prevención secundaria es la anticoagulación oral (anticoagulantes directos o acenocumarol), iniciada precozmente según el tamaño del infarto. Los antiplaquetarios son claramente inferiores para prevenir embolias de origen auricular.

▶ VER CLASE **1.01.2.004** **Infarto agudo al miocardio** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Cardiología 2.2 · SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST
Cardiología 2.3 · SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES
Cardiología 2.4 · Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico: dolor torácico opresivo >20 min con elevación de troponinas sobre el percentil 99 con curva; ECG en <10 min. IAM con SDST: supradesnivel ST ≥1 mm en 2 derivaciones contiguas (≥2 mm en V2–V3) o BCRI nuevo.
- Medidas iniciales: aspirina 250–500 mg masticada, clopidogrel (300 mg; 75 mg si >75 años con trombolisis) o ticagrelor 180 mg, nitroglicerina SL si PAS >90, O2 solo si SatO2 <90%, morfina si dolor refractario.
- IAM con SDST <12 h: reperfusión urgente (GES). Angioplastía primaria si se logra en <120 min; si no, trombolisis en <30 min (tenecteplase ajustado a peso o estreptoquinasa 1,5 millones UI en 1 h). Reperfusión exitosa: descenso ST >50% a los 60–90 min.
- IAM de VD (inferior con V4R+): hipotensión con pulmones limpios → volumen; evitar nitratos, diuréticos y morfina. IAM sin SDST: no trombolizar, anticoagular y estratificar.
- Complicaciones: arritmias (FV la causa de muerte precoz), shock cardiogénico, rotura de papilar (soplo apical + EAP), CIV (soplo paraesternal + frémito), pared libre (taponamiento), pericarditis y Dressler.
- Seguimiento completo: AAS de por vida + P2Y12 por 12 meses, estatina alta intensidad (LDL <55), betabloqueador, IECA/ARA-II, rehabilitación cardíaca y control de factores de riesgo.

PREGUNTAS · 14

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 2.3

Hombre de 60 años consulta en hospital comunal sin hemodinamia por dolor precordial típico de 40 minutos de evolución. ECG revela supradesnivel del ST de 4 mm de V1 a V4. El centro terciario con capacidad de angioplastía está a 150 minutos de traslado. ¿Cuál es la conducta médica de elección?

A Administrar Tenecteplase endovenoso en bolo inmediatamente en el hospital comunal

B Derivar en ambulancia básica a angioplastía primaria sin trombolisis previa

C Administrar heparina en infusión y esperar resultado de troponinas

D Realizar test de esfuerzo para confirmar extensión del infarto

E Indicar nitroglicerina sublingual y reposo absoluto sin fármacos trombolíticos

Respuesta A. Cuando el tiempo para realizar una angioplastía primaria supera los 120 minutos, la guía GES y las normas internacionales obligan a realizar fibrinólisis farmacológica inmediata con Tenecteplase en menos de 30 minutos desde el ingreso para salvar miocardio y reducir la mortalidad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 46

Un paciente de 62 años, con antecedentes de dislipidemia y diabetes en tratamiento con dieta e hipoglicemiantes orales, consulta por dolor toráxico opresivo irradiado a ambos hombros intenso EVA 9/10, asociado a disnea y sudoración. Al examen físico, su presión arterial es 140/70 mmHg con frecuencia cardiaca de 80 latidos por minuto. Pre- senta RR3T con presencia de R3, murmullo pulmonar presente con crépitos bibasales. Electrocardiagrama: SDST en V1-V4. La conducta más adecuada es:

A Tratamiento anticoagulante
B Tratamiento antiplaquetario
C Solicitar AngioTAC de tórax
D Ecocardiograma bidimensional
E Coronariografía de urgencia

Respuesta E. Es un SCA con SDST, por lo que requiere angioplastía de urgencia (o trombolisis, que no aparecía en las opciones).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 52

Hombre de 58 años llega a urgencias con dolor precordial opresivo intenso de 2 horas de evolución, irradiado al brazo izquierdo, sudoración profusa y disnea. ECG: supradesnivel del ST en V1-V4. ¿Cuál es el diagnóstico?

A Insuficiencia cardíaca aguda
B Fibrilación auricular
C Infarto agudo al miocardio con SDST
D Tromboembolismo pulmonar
E Pericarditis aguda

Respuesta C. IAM con SDST: dolor precordial opresivo + irradiación + sudoración + ECG con supradesnivel del ST = IAM con SDST (STEMI). Manejo urgente: aspirina + clopidogrel + anticoagulación + reperfusión (angioplastia primaria o trombolisis según disponibilidad).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 60

Un paciente de 60 años presenta dolor precordial, irradiado al cuello, de 4 horas de evolución, EVA 9/10. Al examen físico está sudoroso, disneico, con RR2T, sin soplos. Se solicita un ECG que se muestra a continuación: ¿Cuál es el tratamiento más importante en este paciente?

A Anticoagulantes
B Revascularización inmediata
C Administración de fuidos intravenosos
D Disminuir la presión arterial
E Oxigenoterapia y antiarrítmicos

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Revascularización inmediata (opción B). Es un IAM con SDST de la pared inferior. Los más importante es revascularizar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 125

Un paciente está hospitalizado por un infarto agudo al miocardio, con supradesnivel del segmento ST, de dos días de evolución. Presenta deterioro del estado general y disnea de reposo, con tendencia a la hipotensión arterial. En su examen físico tiene FC: 115x', PA: 80/50 mmHg, examen pulmonar con crepitaciones bilaterales intensos y examen cardíaco con ritmo regular en 2 tonos, con soplo sistólico intenso, de localización precordial. El diagnóstico más probable es:

A Taponamiento cardíaco por rotura de la pared libre
B Disfunción valvular aórtica isquémica
C Rotura del músculo papilar
D Shock cardiogénico por infarto masivo
E Disección de la raíz aórtica

Respuesta C. Es una rotura clásica del músculo papilar con la insuficiencia mitral secundaria. Insisto, lean el resumen de semiología cardíaca.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 87

Un hombre de 62 años, con antecedentes de hipertensión arterial y tabaquismo, consulta por dolor torácico opresivo de 3 horas de evolución, irradiado al brazo izquierdo, acompañado de náuseas y malestar general. Al ingreso, sus signos vitales son: presión arterial 140/85 mmHg, frecuencia cardíaca 95 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno 96% con aire ambiente, y temperatura 36,8 °C. El examen cardiopulmonar muestra ruidos cardíacos regulares sin soplos y campos pulmonares limpios sin crépitos ni sibilancias. Se solicita electriocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: www.urgenciasyemergen.com): La conducta más adecuada es:

A Solicitar angioTAC de tórax
B Solicitar enzimas cardíacas seriadas
C Realizar angiografía coronaria de emergencia
D Anticoagular con heparina y solicitar ecocardiograma transesofágico
E Iniciar indometacina

Respuesta C. Síndrome Coronario Agudo con Bloqueo de Rama Izquierda: El cuadro clínico sugiere un síndrome coronario agudo. El ECG muestra un BCRI, por lo que se maneja como un SCA con supradesnivel del ST, con angiografía coronaria de urgencia y angioplastia o con trombólisis urgente si la angioplastia no está disponible.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 145

Un paciente de 67 años, usuario de sildenafil, que se automedica como tratamiento de impotencia sexual, presenta dolor torácico intenso, que inició una hora después de haber consumido dicho medicamento. Se solicita un electrocardiograma, que muestra suprdesnivel del segmento ST en las derivaciones inferiores. ¿Qué fármaco está contraindicado en el manejo de este paciente?

A Clopidogrel
B Aspirina
C Atenolol
D Nitroglicerina
E Estreptoquinasa

Respuesta D. La opción correcta es la D (Nitroglicerina). En este escenario clínico, nitroglicerina se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 60

Un paciente de 65 años, diabético e hipertenso, consulta por dolor precordial opresi- vo intenso, EVA: 9/10, asociado a malestar general y disnea. Al examen físico con fre- cuencia cardiaca de 90 por minuto, presión arterial de 150/90 mmHg, al examen cardia- co se ausculta un ritmo regular y tercer ruido. Se realiza estudio con electrocardiogra- ma que muestra supradesnivel del segmento ST en DII, DIII y AVF. Diagnóstico más pro- bable:

A Infarto de pared anterior
B Infarto de pared inferior
C Pericarditis
D Infarto de pared posterior
E Infarto de pared lateral

Respuesta B. Diagnóstico: Infarto de pared inferior (opción B). DII, DIII y AVF son las derivaciones inferiores. El infarto del ventrículo derecho (VD) ocurre como extensión del infarto inferior cuando la oclusión de la coronaria derecha es proximal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 55

Paciente de 63 años, fumador y diabético, que hace una hora comienza con dolor torácico opresivo, intenso, que se irradia a cuello, con diaforesis y sensación de angustia. Se solicita un electrocardiograma, que muestra ritmo sinusal, a 80 lpm, con bloqueo completo de rama izquierda, que no se había visualizado en electrocardiogramas previos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Solicitar enzimas cardíacas
B Solicitar angiografía pulmonar
C Solicitar ecocardiograma transesofágico
D Instalar marcapaso externo transitorio
E Iniciar terapia de reperfusión miocárdica precoz

Respuesta E. El BCRI nuevo es equivalente al SDST en el manejo del infarto, así que se debe reperfundir de inmediato, idealmente con angioplastía (o bien con trombolisis si no está disponible la angioplastía en menos de 90 minutos).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 42

Un paciente de 60 años consulta por dolor precordial opresivo irradiado a mandíbula de 40 minutos de evolución, asociado a sudoración. El electrocardiograma muestra supradesnivel del segmento ST en derivaciones DII, DIII y aVF. ¿Cuál es la principal complicación temprana de este cuadro?

A Insuficiencia mitral aguda.
B Rotura de pared libre.
C Arritmias ventriculares.
D Taponamiento cardíaco.
E Fibrilación auricular.

Respuesta C. El infarto con supradesnivel del ST en cara inferior (DII, DIII, aVF) tiene como complicación temprana más frecuente las arritmias ventriculares, que son la principal causa de muerte en las primeras horas. La rotura de pared libre y la insuficiencia mitral aguda por rotura del músculo papilar son complicaciones mecánicas más tardías y menos frecuentes, y el taponamiento es consecuencia de la rotura.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 11

Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso en tratamiento con dieta, consulta por dolor torácico incitrante, intenso, asociado a sudoración y malestar general. Al examen físico está sudoroso, inquieto, con FC: 70x', PA: 120/80 mmHg, RR2T sin soplos. Se solicita un electrocardiograma que muestra un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Qué tratamiento se debe indicar en este momento?

A Aspirina y clopidogrel
B Lidocaína y heparina
C Morfina y nitritos
D Atenolol e hidroclorotiazida
E Digoxina y enalapril

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Aspirina y clopidogrel (opción A). Es un síndrome coronario agudo. El BCRI es equivalente a un SDST.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 157

ECG con supra st DII, DIII y aVF- medida inicial más adecuada:

A Reperfusión

B Doble antiagregación (PORQUE NO PODRÍA SER)

C Insuficiencia cardíaca

D Fibrilación auricular

E Infarto agudo al miocardio

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Reperfusión). El infarto del ventrículo derecho (VD) ocurre como extensión del infarto inferior cuando la oclusión de la coronaria derecha es proximal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 44

Un paciente de 23 años consulta en el servicio de urgencia, por dolor torácico de 2 horas de evolución, intenso, asociado a diaforesis y palpitaciones, que inició algunos minutos después de haber inhalado cocaína. Al examen físico presenta FC: 120x', PA: 190/120 mmHg, ritmo regular en dos tonos, sin soplos. Su electrocardiograma muestra supradesnivel de segmento ST en las derivaciones de la pared anterior. ¿Qué fármaco está contraindicado en el manejo de este paciente?

A Estreptoquinasa

B Clopidogrel

C Nitroglicerina

D Atenolol

E Diazepam

Respuesta D. El betabloqueo está contraindicado en la intoxicación por cocaína, ya que su esto exacerbaría su acción alfa-adrenérgica, pudiendo generar crisis hipertensivas y muerte. Lo que sí está indicado son las benzodiacepinas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 96

Paciente con IAM con SDST llega a hospital sin capacidad de angioplastia primaria. El centro con ICPP más cercano se encuentra a 60 minutos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Trombolisis inmediata y traslado a centro con hemodinamia

B Esperar traslado a centro con angioplastia

C Angioplastia de rescate de urgencia en el mismo centro

D Manejo médico solo con heparina y AAS

E Trombolisis y no trasladar

Respuesta A. IAM SDST sin capacidad de ICPP: si el traslado a centro con angioplastia demora >120 min desde el primer contacto médico, se realiza trombolisis inmediata + traslado para angiografía en 3-24h.

▶ VER CLASE **1.01.2.005** **Insuficiencia cardíaca aguda**

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Cardiología 3.3 · Edema Agudo de Pulmón & Cuadrícula de Forrester
Cardiología 3.4 · Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks

QUÉ HAY QUE SABER

- IC aguda: aparición o empeoramiento rápido de síntomas; edema pulmonar con disnea intensa, ortopnea, crépitos bilaterales, expectoración rosada, hipoxemia. Buscar gatillante: isquemia, arritmia, HTA, infección, abandono de tratamiento.
- Confirmación: Rx de tórax (congestión, líneas B de Kerley, derrame), ECG, troponina, BNP/NT-proBNP y gases; ecocardiograma precoz.
- Perfiles de Forrester/Stevenson: caliente-húmedo (el más frecuente) → diuréticos + vasodilatadores; frío-húmedo (shock) → inótropos/vasopresores; frío-seco → volumen cauteloso.
- Edema pulmonar hipertensivo: sentado, O2 si SatO2 <90%, VNI (CPAP/BiPAP) si dificultad respiratoria, furosemida 40–80 mg EV, nitroglicerina SL o EV (si PAS >110). Morfina no de rutina.
- Shock cardiogénico: noradrenalina + dobutamina, revascularización urgente si es isquémico.
- Seguimiento: hospitalizar y derivar a cardiología/UCI; al alta, optimizar terapia de IC y control precoz.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 3.3

Hombre de 70 años con edema agudo de pulmón hipertensivo (PA 200/110 mmHg, $SatO_2$ 82%). ¿Cuál es la terapia respiratoria no farmacológica de primera línea más efectiva para evitar la intubación orotraqueal?

A Ventilación no invasiva con presión positiva continua (CPAP)

B Oxigenoterapia por cánula nasal a 2 litros por minuto

C Intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva inmediata

D Nebulización continua con Salbutamol

E Aspiración traqueal a circuito abierto

Respuesta A. La Ventilación No Invasiva (VNI) en modalidad CPAP es la medida más costo-efectiva y de primera línea en el edema agudo de pulmón cardiogénico: recluta alvéolos inundados de líquido, mejora la oxigenación y reduce la precarga y poscarga, disminuyendo drásticamente la tasa de intubación endotraqueal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 88

(88) Paciente de 82 años con historia de 2 semanas de disnea progresiva FC 92 lpm PA 200/100 SatO2 90%. Al examen físico ingurgitación yugular, ritmo regular en tres tiempos por R3 al examen pulmonar créditos bibasales. ECG: ritmo sinusal con signos de sobrecarga del VI. Diagnóstico más probable:

A SCA

B Disección aórtica

C NAC

D IC aguda

E TEP f. Dolor torácico súbito, transfixiante, HTA y soplo diastólico.

Respuesta D. Diagnóstico: IC aguda (opción D). Esta clase aborda la interpretación del equilibrio ácido-base mediante gasometría arterial o venosa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 152

Paciente que tenía una insuficiencia cardiaca aguda, con tercer ruido.

A Cor pulmonale del EPOC

B Insuficiencia cardíaca descompensada

C Fibrilación auricular

D Infarto agudo al miocardio

E Tromboembolismo pulmonar

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Insuficiencia cardíaca descompensada). Esta clase aborda la interpretación del equilibrio ácido-base mediante gasometría arterial o venosa.

▶ VER CLASE 1.01.2.006 Paro cardiorespiratorio

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 1.2 · Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

QUÉ HAY QUE SABER

- Reconocer el paro: paciente que no responde y no respira o solo boquea → pedir ayuda/DEA y comenzar RCP sin buscar pulso por más de 10 s.
- RCP de alta calidad: compresiones 100–120/min, profundidad 5–6 cm, reexpansión completa, mínimas interrupciones, relación 30:2 sin vía aérea avanzada; cambiar reanimador c/2 min.
- Ritmos desfibrilables (FV/TV sin pulso): descarga precoz (200 J bifásico) y reanudar RCP de inmediato por 2 min; adrenalina 1 mg EV tras la 2ª descarga c/3–5 min; amiodarona 300 mg tras la 3ª (luego 150 mg).
- No desfibrilables (asistolia/AESP): RCP + adrenalina 1 mg lo antes posible y c/3–5 min; nunca desfibrilar la asistolia.
- Buscar causas reversibles (5H y 5T): hipoxia, hipovolemia, H+ (acidosis), hipo/hiperkalemia, hipotermia; neumotórax a tensión, taponamiento, tóxicos, trombosis pulmonar y coronaria.
- Tras recuperar circulación: SatO2 92–98%, PAS >90/PAM >65, ECG de 12 derivaciones (coronariografía si SDST), control de temperatura y derivación a UCI.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 120

Diabético hipertenso con dolor torácico súbito, luego compromiso de conciencia y ausencia de pulso. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Desfibrilación inmediata sin RCP previa

B Iniciar compresiones torácicas externas (RCP)

C Intubación orotraqueal inmediata

D Administrar adrenalina 1 mg EV de inmediato

E Acceso venoso y carga de volumen

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Iniciar compresiones torácicas externas (RCP) (opción B). Iniciar compresiones torácicas externas (RCP). Actualmente no se diferencia el manejo entre agua salada y agua dulce.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 55

Un paciente de 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo de 20 paquetes año, consulta en el servicio de urgencia, por dolor precordial opresivo. Luego de su ingreso, presenta compromiso de conciencia, sin respuesta. Al examen físico no respira y es imposible palpar el pulso carotídeo. Además de solicitar ayuda, la conducta inicial más adecuada es:

A Realizar compresiones toráxicas
B Realizar intubación orotraqueal
C Dar golpe toráxico
D Desfibrilar
E Administrar adrenalina endovenosa

Respuesta A. Aunque se trate de un paro presenciado, que clásicamente se manejaba con desfibrilación inmediata, aquello solo ocurre cuando, además, está monitorizado, con desfibrilador a mano y se constata que tiene un ritmo desfibrilable de inmediato. De lo contrario, como en este caso (y la mayoría de los casos reales) siempre se debe solicitar ayuda e inmediatamente iniciar con las compresiones torácicas, mientras llega el resto del equipo con el desfibrilador y el carro de paro (con adrenalina,...

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 60 años se desploma en la sala de espera. No responde y no respira. Se inicia RCP y se conecta el monitor-desfibrilador, que muestra fibrilación ventricular. Se administra una descarga de 200 J. **¿Cuál es el paso inmediato siguiente?**

A Palpar pulso carotídeo durante 10 segundos
B Administrar adrenalina 1 mg EV antes de continuar
C Reanudar compresiones torácicas por 2 minutos
D Administrar amiodarona 300 mg EV
E Intubar al paciente antes de seguir con las compresiones

Respuesta C. Después de cada descarga se reanuda de inmediato la RCP por 2 minutos sin chequear pulso ni ritmo. La adrenalina se indica tras la 2ª descarga y la amiodarona tras la 3ª en ritmos desfibrilables refractarios.

▶ VER CLASE 1.01.2.007 Shock

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Cardiología 3.4 · Shock Cardiogénico & Diagnóstico Diferencial de los 4 Shocks

QUÉ HAY QUE SABER

- Shock: hipoperfusión tisular con hipotensión (PAS <90 o PAM <65 mmHg), taquicardia, oliguria (<0,5 mL/kg/h), compromiso de conciencia, llene capilar lento y lactato >2 mmol/L.
- Clasificar: hipovolémico (piel fría, yugulares planas), cardiogénico (piel fría, crépitos, yugulares ingurgitadas), distributivo/séptico (piel tibia, RVS baja), obstructivo (TEP, taponamiento, neumotórax a tensión: yugulares ingurgitadas).
- Manejo inicial: ABC, O2, 2 vías venosas gruesas, monitorización, sonda Foley, lactato, hemocultivos si sospecha de sepsis; ECG y ecografía a pie de cama para orientar.
- Hipovolémico/séptico: cristaloides 30 mL/kg en la primera hora y reevaluar; sepsis: antibióticos en la primera hora; hemorrágico: control del sangrado y hemoderivados.
- Noradrenalina es el vasopresor de elección (meta PAM ≥65); dobutamina si bajo gasto cardiogénico. Obstructivo: descompresión del neumotórax, pericardiocentesis o trombolisis según causa.
- Seguimiento: derivar a UCI y al especialista según la causa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 3.4

Hombre de 58 años en shock cardiogénico refractario a volumen tras infarto agudo al miocardio. Presenta PA 75/45 mmHg y signos de hipoperfusión. ¿Cuál es el vasopresor de primera línea recomendado para restaurar la presión arterial media?

A Noradrenalina en infusión continua
B Dopamina en dosis altas
C Fenilefrina en bolo
D Isoproterenol endovenoso
E Epinefrina subcutánea

Respuesta A. La Noradrenalina es el vasopresor de primera línea en el shock cardiogénico: posee un potente efecto alfa-1 vasoconstrictor y un moderado efecto beta-1 inótropo, logrando elevar la PAM con significativamente menor riesgo de taquiarritmias y menor mortalidad comparada con la Dopamina.

▶ VER CLASE 1.01.2.008 Taponamiento pericárdico

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Cardiología 5.3 · Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco
Cirugía 11.10 · Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante

QUÉ HAY QUE SABER

- Taponamiento: acumulación pericárdica que compromete el llenado; causas trauma penetrante, neoplasia, pericarditis, uremia, rotura de pared post IAM, disección aórtica, post cirugía cardíaca.
- Tríada de Beck: hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados; pulso paradójico (caída de PAS >10 mmHg en inspiración), taquicardia, signo de Kussmaul.
- Confirmación: ecocardiograma (derrame con colapso diastólico de cavidades derechas) o FAST en trauma; ECG con bajo voltaje y alternancia eléctrica; Rx con silueta en 'botellón'.
- Manejo inicial: volumen EV para mantener precarga; evitar diuréticos, vasodilatadores y ventilación con presión positiva si es posible.
- Tratamiento definitivo: pericardiocentesis descompresiva urgente (subxifoidea, idealmente ecoguiada); en trauma, toracotomía/ventana pericárdica. En disección aórtica no puncionar: cirugía.
- Seguimiento: derivar a cardiología/cirugía para drenaje definitivo y estudio etiológico.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 3

Un paciente con antecedente de ser fumador de 30 paquetes año, suspendido hace 5 años, consulta por un cuadro de 24 horas de disnea de mínimos esfuerzos, asociada a intolerancia al ejercicio y malestar general. Al examen físico su presión arterial es 90/60 y su frecuencia cardíaca 110. Además destacan yugulares ingurgitadas a 45 grados y ruidos cardíacos apagados a la auscultación. Su electrocardiograma muestra disminución difusa del voltaje. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Tromboembolismo pulmonar
B Neumotórax
C Derrame pleural
D Infarto agudo al miocardio
E Taponamiento cardíaco

Respuesta E. Hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados forman la tríada de Beck. El bajo voltaje difuso en el electrocardiograma apoya un derrame pericárdico, aquí probablemente neoplásico por el tabaquismo. Se confirma con ecocardiograma y se trata con pericardiocentesis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 158

Clínica de taponamiento, hipotensión, pulsos disminuidos como realizo el diagnóstico:

A Ecocardiograma
B Hemograma y VHS
C Ecografía
D Radiografía
E TAC con contraste

Respuesta A. Diagnóstico: Ecocardiograma (opción A).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 136

Un paciente de 79 años, con antecedente de cáncer de pulmón en espera de tratamiento, presenta un cuadro de 5 días de malestar general, disnea y episodios de pérdida de conocimiento de pocos segundos de duración, con recuperación completa. El examen físico muestra presión arterial: 80/60 mmHg, frecuencia cardíaca: 110x' regular, cuello con ingurgitación yugular a 50 grados. El examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, sin otros ruidos agregados y la auscultación cardíaca es difícil de realizar, ya que los ruidos cardíacos se encuentran apagados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Tromboembolismo pulmonar
B Taponamiento cardíaco
C Derrame pleural
D Síndrome de la vena cava superior
E Insuficiencia tricuspídea

Respuesta B. Taponamiento Cardíaco: Aunque el antecedente de cáncer, la hipotensión y la disnea sugieren un tromboembolismo pulmonar, la disminución de la intensidad de los ruidos cardíacos apunta a derrame pericárdico con taponamiento, también compatible con el antecedente de cáncer y el resto de la clínica. Se recomienda revisar el resumen de semiología cardíaca.

▶ VER CLASE 1.01.2.009 Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Cardiología 1.4 · TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White
Cardiología 1.5 · Bradicardias Sintomáticas & Bloqueos AV (GES Marcapasos)

QUÉ HAY QUE SABER

- Inestabilidad atribuible a la arritmia: hipotensión, signos de shock, compromiso de conciencia, dolor torácico isquémico o IC aguda.
- Taquiarritmia inestable (FC habitualmente >150 lpm): cardioversión eléctrica sincronizada inmediata con sedación (TPSV/flutter 50–100 J; FA 120–200 J bifásico; TV monomorfa 100 J). TV sin pulso: desfibrilar.
- Taquicardia de QRS ancho estable: asumir TV; amiodarona 150 mg EV en 10 min. Nunca verapamilo en QRS ancho.
- Bradiarritmia inestable: atropina 1 mg EV c/3–5 min (máximo 3 mg); si falla, marcapaso transcutáneo o infusión de dopamina (5–20 µg/kg/min) o adrenalina (2–10 µg/min).
- Buscar y corregir causas: hiperkalemia, isquemia, hipoxia, intoxicación (digoxina, betabloqueadores, calcioantagonistas), hipotermia.

- Seguimiento: derivar a cardiología/UCI (marcapaso definitivo, ablación o DAI según el caso).

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 1.5

Paciente de 85 años ingresa a SAPU en shock cardiogénico con FC de 28 lpm por BAV de tercer grado. Se administra Atropina 1 mg EV sin respuesta de la frecuencia cardíaca ni de la presión arterial. ¿Cuál es el paso inmediato que debe realizar el médico tratante?

A Instalar marcapaso externo transcutáneo e iniciar infusión de Adrenalina
B Repetir Atropina hasta completar 6 mg
C Administrar Amiodarona 300 mg endovenosa
D Realizar cardioversión eléctrica sincronizada a 100 J
E Derivar en ambulancia básica sin monitor

Respuesta A. En una bradiarritmia con inestabilidad hemodinámica que no responde a la dosis inicial de atropina, la conducta de emergencia perentoria es la estimulación eléctrica mediante marcapaso transcutáneo externo asociada al inicio de drogas vasoactivas (Adrenalina o Dopamina) mientras se prepara el marcapaso transvenoso.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 4

Un paciente ingresa al servicio de urgencia, por un cuadro de disnea marcada y síncopes. Al examen físico está confuso, con pulso de 200 latidos por minuto, regular y presión arterial de 70/40 mmHg. Además, tiene frialdad de extremidades y piel sudorosa. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado en este momento?

A Maniobras vagales
B Amiodarona endovenosa
C Adenosina endovenosa
D Desfibrilación
E Cardioversión eléctrica

Respuesta E. Por tener compromiso hemodinámico, da igual de qué taquiarritmia se trate y se debe cardiovertir eléctricamente (no confundir con la desfibrilación, que se usa en el paro con FV o TVSP).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 177

Un paciente de 65 años, con antecedente de un infarto agudo al miocardio, hace 2 años, presenta un síncope, con compromiso de conciencia que requirió maniobras de reanimación para recuperarse. ¿Qué arritmia es la que debe descartarse en primer lugar?

A Taquicardia paroxística supraventricular
B Bloqueo auriculoventricular completo
C Síndrome de Wolff Parkinson White
D Taquicardia ventricular
E Fibrilación auricular

Respuesta D. Si bien cualquier arritmia se puede presentar así, el antecedente de un IAM previo orienta mucho a TV. Además, la TV suele ser más grave y letal que las demás, por lo que la necesidad de maniobras de reanimación orienta también a TV.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 93

Un paciente hipertenso en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida, y con antecedentes de asma en tratamiento con inhaladores, consulta por palpitaciones, asociadas a disnea y angustia. Al examen físico se constata taquicardia con frecuencia cardíaca de 124 latidos por minuto y presión arterial de 80/40 mmHg. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a continuación (fuente: myekg.com): ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Desfibrilación
B Amiodarona endovenosa
C Propranolol endovenoso
D Adenosina endovenosa
E Cardioversión eléctrica

Respuesta E. Manejo de la Fibrilación Auricular Hemodinámicamente Inestable: En el caso de una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida que cause inestabilidad hemodinámica, se debe realizar cardioversión eléctrica inmediata (no confundirla con la desfibrilación eléctrica, que se usa en el paro). Este manejo se aplica a cualquier tipo de taquiarritmia con hemodinamia inestable. Si la fibrilación auricular hubiera presentado una hemodinamia estable, el manejo inicial habría sido disminuir la...

Conocimientos generales

7 códigos

▶ VER CLASE `1.01.3.001` **Alimentación saludable**

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.6 · Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Guías Alimentarias para Chile: comer verduras y frutas al menos 5 porciones al día, legumbres 2 veces por semana, pescado 2 veces por semana, lácteos descremados 3 veces al día y agua 6–8 vasos diarios.
- Reducir sal a <5 g/día (evitar salero y embutidos), azúcares añadidos <10% de las calorías y grasas saturadas/trans; preferir aceites vegetales y frutos secos.

- Ley de etiquetado (Ley 20.606): sellos 'ALTO EN' calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas; preferir alimentos con menos sellos y no procesados.
- Patrones con beneficio cardiovascular demostrado: dieta mediterránea y DASH (reduce PA ~8–14 mmHg).
- Distribuir en 4 comidas, evitar ultraprocesados y bebidas azucaradas; ajustar calorías al gasto para mantener IMC 18,5–24,9.
- Población objetivo: todas las edades; énfasis en personas con riesgo cardiovascular (Programa de Salud Cardiovascular, programa Elige Vivir Sano/Vida Sana).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 50 años, normotenso, con IMC de 26 kg/m², consulta para recibir consejería alimentaria de prevención cardiovascular. Refiere que agrega sal a las comidas y consume pan, embutidos y snacks a diario. **¿Cuál es el consumo máximo diario de sal recomendado para un adulto?**

A 1 g/día

B 15 g/día

C 10 g/día

D Menos de 5 g/día (una cucharadita)

E No hay límite si la presión arterial es normal

Respuesta D. La OMS y las guías chilenas recomiendan menos de 5 g de sal al día (unos 2 g de sodio). Reducir la sal baja la presión arterial, también en normotensos, y disminuye el riesgo cardiovascular. La mayor parte proviene de alimentos procesados como pan y embutidos, no solo del salero.

▶ VER CLASE 1.01.3.002 Cardiopatía y embarazo

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.21 · Cardiopatía, Embarazo Múltiple e Hiperemesis Gravídica: Riesgo Materno, Corionicidad y Manejo Inicial

QUÉ HAY QUE SABER

- El embarazo aumenta el volumen plasmático (~50%) y el gasto cardíaco, con máximo hacia las 28–32 semanas y sobrecarga en el parto y posparto inmediato; soplo sistólico eyectivo leve y edema son fisiológicos.
- Alto riesgo materno (embarazo contraindicado o desaconsejado): hipertensión pulmonar/Eisenmenger, FEVI <30%, estenosis mitral o aórtica severa, coartación severa, Marfan con aorta dilatada y miocardiopatía periparto previa con disfunción residual.
- Contraindicados en el embarazo: IECA, ARA-II, sacubitrilo/valsartán, estatinas, amiodarona (relativa), espironolactona y DOAC; warfarina/acenocumarol teratogénicos en el 1er trimestre (preferir HBPM).
- Seguros: metildopa, labetalol y nifedipino para HTA; betabloqueadores (metoprolol, bisoprolol) para arritmias; heparinas para anticoagulación.
- Miocardiopatía periparto: IC con FEVI <45% en el último mes de embarazo o primeros 5 meses posparto; sospechar ante disnea y edema desproporcionados.
- Manejo: consejo preconcepcional, control conjunto obstetricia-cardiología en centro de alta complejidad; el parto vaginal con analgesia epidural es de elección en la mayoría.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 28 años, con una cardiopatía conocida, consulta en control preconcepcional porque desea embarazarse. **¿En cuál de las siguientes condiciones se debe desaconsejar el embarazo por su alta mortalidad materna?**

A Comunicación interauricular reparada

B Prolapso de válvula mitral sin insuficiencia significativa

C Hipertensión arterial pulmonar severa (síndrome de Eisenmenger)

D Extrasistolía ventricular benigna

E Insuficiencia mitral leve

Respuesta C. La hipertensión arterial pulmonar severa, incluido el síndrome de Eisenmenger, tiene mortalidad materna muy alta (clase IV de la OMS modificada) y contraindica el embarazo. Las lesiones reparadas, el prolapso mitral sin insuficiencia y las insuficiencias valvulares leves se toleran bien, porque el embarazo disminuye la resistencia vascular sistémica.

▶ VER CLASE 1.01.3.003 Manejo del paciente en tratamiento anticoagulante

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 1.3 · Fibrilación Auricular & Flutter Auricular (Guía GES MINSAL)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: FA o flutter con CHA2DS2-VASc indicativo, TVP/TEP, prótesis valvular mecánica, estenosis mitral con FA, trombo intracavitario.
- Acenocumarol/warfarina: meta INR 2–3 (2,5–3,5 en prótesis mitral mecánica); controles de INR frecuentes al inicio y luego cada 4 semanas; múltiples interacciones (antibióticos, amiodarona, AINE) y dieta (vitamina K) estable, no suprimida.
- DOAC (apixabán, rivaroxabán, dabigatrán): no requieren INR; ajustar por función renal, edad y peso; contraindicados en prótesis mecánica y estenosis mitral moderada-severa.
- INR supraterapéutico sin sangrado: suspender o reducir dosis; INR >10 o sangrado: vitamina K (oral 1–2,5 mg; EV en sangrado mayor) + complejo protrombínico o plasma fresco congelado.
- Procedimientos: suspender AVK ~5 días antes (puente con HBPM solo en alto riesgo trombótico) y DOAC 24–48 h según riesgo y VFG; procedimientos menores (dentales) en general sin suspender.

- Educar: adherencia, signos de sangrado, evitar AINE y automedicación, interacciones; evaluar riesgo de caídas y sangrado (HAS-BLED) para corregir factores modificables.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 150

Un paciente de 62 años, con antecedente de prótesis mecánica de válvula mitral e insuficiencia renal crónica, con un clearence de creatinina estimado de 20 ml/min, presenta un cuadro de palpitaciones. Se realiza electrocardiograma que muestra una taquiarritmia irregular con QRS angosto y ausencia de onda P. **¿Qué tratamiento es el más adecuado para su manejo?**

A Apixabán
B Enoxaparina
C Dabigatrán
D Acenocumarol
E Rivaroxabán

Respuesta D. Fibrilación auricular en un portador de válvula mecánica mitral: el anticoagulante de elección es el cumarínico, con meta de INR 2,5 a 3,5. Los anticoagulantes orales directos no se usan en las prótesis valvulares mecánicas, y la insuficiencia renal grave también limita las heparinas de bajo peso molecular.

▶ VER CLASE 1.01.3.004 Obesidad y sobrepeso

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.6 · Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Clasificación por IMC (adulto): sobrepeso 25–29,9; obesidad I 30–34,9, II 35–39,9, III ≥40 kg/m². Adulto mayor: obesidad con IMC ≥32. Obesidad abdominal: cintura ≥90 cm en hombres y ≥80 cm en mujeres.
- Factor de riesgo de DM2, HTA, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, SAHOS, hígado graso, artrosis y varios cánceres; descartar causas secundarias (hipotiroidismo, Cushing, fármacos).
- Tratamiento base: déficit calórico de 500–1000 kcal/día, actividad física 150–300 min/semana y terapia conductual; meta inicial bajar 5–10% del peso en 6 meses.
- Farmacoterapia si IMC ≥30 o ≥27 con comorbilidad: agonistas GLP-1 (liraglutida, semaglutida), orlistat, naltrexona/bupropión.
- Cirugía bariátrica si IMC ≥40 o ≥35 con comorbilidad (≥30–35 con DM2 mal controlada) tras fracaso del tratamiento médico.
- Programas chilenos: Vida Sana (prevención en APS), EMP para tamizaje, Ley de etiquetado y Elige Vivir Sano.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 40 años pesa 78 kg y mide 1,60 m. Su circunferencia de cintura es de 94 cm. No tiene comorbilidades conocidas. **¿Cómo se clasifica su estado nutricional según el IMC?**

A Normal
B Obesidad grado I
C Sobrepeso
D Obesidad grado II
E Obesidad mórbida

Respuesta B. IMC = 78 / (1,60)² ≈ 30,5 kg/m². En adultos: 18,5-24,9 normal, 25-29,9 sobrepeso, 30-34,9 obesidad I, 35-39,9 obesidad II y ≥40 obesidad mórbida. Además, una cintura sobre 88 cm en mujeres indica obesidad abdominal y mayor riesgo cardiometabólico.

▶ VER CLASE 1.01.3.005 Prevención de enfermedad reumática

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.13 · Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

QUÉ HAY QUE SABER

- Prevención primaria: tratar la faringoamigdalitis estreptocócica con penicilina benzatina 1.200.000 UI IM (600.000 UI si <27 kg) dosis única o amoxicilina 50 mg/kg/día por 10 días; previene la fiebre reumática si se inicia hasta 9 días después del inicio.
- Alergia a penicilina: macrólido (azitromicina 5 días o eritromicina 10 días) o cefalosporina de primera generación si la alergia no es anafiláctica.
- Prevención secundaria tras fiebre reumática: penicilina benzatina 1.200.000 UI IM cada 21–28 días (alternativa penicilina V oral 250 mg c/12 h o eritromicina si alergia).
- Duración: sin carditis 5 años o hasta los 21 años; carditis sin secuela 10 años o hasta los 21; carditis con secuela valvular 10 años o hasta los 40 (de por vida en alto riesgo).
- No usar antibióticos en faringitis viral; diagnóstico clínico (Centor/McIsaac) o test rápido en niños 5–15 años.
- Medidas sociales: hacinamiento y pobreza favorecen la transmisión; la fiebre reumática es hoy poco frecuente en Chile pero sigue siendo causa de valvulopatía en adultos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 8 años presenta fiebre de 39 °C, odinofagia, exudado amigdalino, adenopatías cervicales anteriores dolorosas y ausencia de tos. El test rápido para estreptococo grupo A es positivo. No tiene alergias. **¿Cuál es el tratamiento que, además de aliviar los síntomas, previene la fiebre reumática?**

A Azitromicina por 3 días

B Ibuprofeno y control en 48 horas

C Cefadroxilo por 3 días

D Amoxicilina por 10 días

E Amoxicilina por 3 días

Respuesta D. La prevención primaria de la fiebre reumática es tratar la faringoamigdalitis estreptocócica con amoxicilina por 10 días o penicilina benzatina intramuscular en dosis única; previene la enfermedad aun iniciada hasta 9 días después del inicio. Los cursos de 3 días no erradican de forma confiable el estreptococo; los macrólidos se reservan para alérgicos.

▶ VER CLASE 1.01.3.006 Sedentarismo vs actividad física

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 1.5 · Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular

QUÉ HAY QUE SABER

- Sedentarismo: factor de riesgo cardiovascular independiente; en Chile más del 80% de los adultos es sedentario (ENS).
- Recomendación OMS adultos: 150–300 min/semana de actividad aeróbica moderada o 75–150 min vigorosa + fortalecimiento muscular ≥2 días/semana; reducir tiempo sentado.
- Adultos mayores: agregar ejercicios de equilibrio y fuerza ≥3 días/semana para prevenir caídas. Niños y adolescentes: 60 min diarios de actividad moderada a vigorosa.
- Beneficios: baja la PA (~5–8 mmHg), mejora la sensibilidad a la insulina, sube el HDL, reduce peso, mortalidad cardiovascular, depresión y riesgo de algunos cánceres.
- Evaluación preparticipativa: solicitar evaluación cardiológica (test de esfuerzo) en sintomáticos o con cardiopatía conocida antes de ejercicio vigoroso; síntomas de alarma durante el ejercicio: dolor torácico, síncope, disnea desproporcionada.
- Programas: Vida Sana, Elige Vivir Sano y consejería breve en el EMPA y controles del Programa de Salud Cardiovascular.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 45 años, oficinista, sedentario y sin enfermedades, pregunta cuánta actividad física necesita para reducir su riesgo cardiovascular. **¿Cuál es la recomendación mínima de actividad física para adultos?**

A 30 minutos de caminata una vez por semana

B Solo actividad física si tiene sobrepeso

C 20 minutos diarios de elongación

D 60 minutos de ejercicio intenso todos los días, sin excepción

E 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, más fortalecimiento muscular 2 días por semana

Respuesta E. La OMS recomienda al menos 150 a 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada (o 75 a 150 vigorosa), más ejercicios de fuerza 2 o más días por semana, y reducir el tiempo sentado. El sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular independiente, incluso con peso normal.

▶ VER CLASE 1.01.3.007 Tabaquismo: prevención, cesación y efectos nocivos para la salud

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 1.4 · Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

QUÉ HAY QUE SABER

- Tabaco: principal causa evitable de muerte; factor de riesgo de enfermedad coronaria, ACV, EPOC, cáncer pulmonar, vesical, laríngeo, entre otros. El riesgo cardiovascular cae a la mitad al año de dejar de fumar.
- Estrategia de las 5A en cada consulta: Averiguar, Aconsejar, Acordar/Evaluar disposición, Ayudar y Acompañar; consejería breve de 3–5 min aumenta la cesación. Si no está dispuesto: 5R (motivacional).
- Farmacoterapia: terapia de reemplazo de nicotina (parches 21 mg/día + chicles/comprimidos), vareniclina 0,5 mg/día titulada a 1 mg c/12 h por 12 semanas (la más eficaz) o bupropión 150 mg/día titulado a c/12 h (contraindicado en epilepsia y TCA).
- Fijar fecha de cesación (día D); síntomas de abstinencia máximos en la primera semana; seguimiento a la semana, al mes y a los 3 meses.
- Prevención: Ley 20.660 (ambientes libres de humo, prohibición de publicidad), advertencias gráficas e impuestos; evaluar tabaquismo en el EMPA y en embarazo.
- Derivar a programas de cesación o especialista si dependencia severa, fracasos previos o comorbilidad psiquiátrica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 52 años fuma 20 cigarrillos al día desde los 18 años. En el control refiere que quiere dejar de fumar en las próximas semanas. Fuma el primer cigarrillo a los 5 minutos de despertar. No tiene antecedentes de convulsiones ni de enfermedad psiquiátrica. **Además de la consejería, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Fijar una fecha de cese e indicar farmacoterapia (vareniclina o terapia de reemplazo de nicotina)

B Indicar reducir gradualmente a 10 cigarrillos y reevaluar en 1 año

C Cambiar a cigarrillo electrónico en forma indefinida

D Indicar benzodiacepinas para la ansiedad

E Esperar que lo intente sola antes de indicar fármacos

Respuesta A. Está en etapa de preparación y tiene alta dependencia (primer cigarrillo antes de 30 minutos). Se indica consejería, fecha de cese y farmacoterapia de primera línea: vareniclina, terapia de reemplazo de nicotina o bupropión. Combinar consejería y fármacos multiplica las tasas de abstinencia; solo reducir no es cesación.

Exámenes e imagenología

13 códigos

▶ VER CLASE 1.01.4.001 **Coronariografía** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 2.1 · Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen de referencia (gold standard) para definir anatomía coronaria; diagnóstica y terapéutica (angioplastía con stent en el mismo acto).
- Indicaciones: IAM con SDST (angioplastía primaria), SCA sin SDST de alto riesgo (<24 h), angina estable con test no invasivo de alto riesgo o refractaria a tratamiento, paro recuperado, IC de causa no aclarada, estudio prequirúrgico valvular.
- Lesión significativa: estenosis ≥70% en una arteria epicárdica o ≥50% en el tronco coronario izquierdo; informa número de vasos, FEVI (ventriculografía) y anatomía para decidir angioplastía o bypass.
- Bypass (cirugía) preferido en tronco común, enfermedad de 3 vasos o multivaso en diabéticos; angioplastía en enfermedad de 1–2 vasos y en el SCA.
- Complicaciones: hematoma o pseudoaneurisma en el sitio de punción (menor por vía radial), nefropatía por contraste (hidratar, suspender metformina), alergia al contraste, arritmias, disección coronaria.
- Tras stent: doble antiagregación (aspirina + clopidogrel/ticagrelor) por 6–12 meses según indicación; no suspender sin consultar a cardiología.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 155

Test de esfuerzo alterado cual era el siguiente paso?: a. Coronariografía

A Insuficiencia cardíaca

B Fibrilación auricular

C Infarto agudo al miocardio

D Tromboembolismo pulmonar

E Pericarditis aguda

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Insuficiencia cardíaca).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 62 años, diabético, con angina de esfuerzo. Test de esfuerzo: infradesnivel del ST de 3 mm en el primer estadio de Bruce con caída de la presión arterial. Se realiza coronariografía que muestra estenosis de 80% del tronco coronario izquierdo y lesiones significativas en la descendente anterior y la coronaria derecha. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Cirugía de revascularización coronaria (bypass)

B Angioplastía con balón sin stent

C Tratamiento médico exclusivo y nuevo test en 6 meses

D Trombolisis con tenecteplase

E Repetir coronariografía en 3 meses

Respuesta A. Estenosis del tronco ≥50% y enfermedad multivaso en un diabético son indicación clásica de bypass coronario, que mejora la sobrevida frente a la angioplastía o el tratamiento médico. La trombolisis no tiene rol en la enfermedad coronaria estable.

▶ VER CLASE 1.01.4.002 **Angiotac de tórax y aorta** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 5.4 · Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal
Cardiología 5.5 · Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP)

QUÉ HAY QUE SABER

- AngioTAC de tórax/aorta: TAC con contraste EV en fase arterial; examen de elección para TEP (angioTAC pulmonar) y para disección aórtica aguda.
- TEP: defecto de llene en arterias pulmonares; también informa dilatación del VD (relación VD/VI >1, peor pronóstico) e infartos pulmonares.

- Disección aórtica: flap intimal con lumen verdadero y falso; el informe define Stanford A (ascendente → cirugía urgente) o B (descendente → manejo médico) y compromiso de ramas.
- Otros: aneurisma de aorta torácica (diámetro, crecimiento), síndrome aórtico agudo (hematoma intramural, úlcera penetrante), coartación.
- Precauciones: insuficiencia renal (hidratar; evaluar riesgo/beneficio), alergia al contraste (premedicar), metformina (suspender 48 h si VFG <30–45), embarazo (preferir otra técnica en TEP si es posible).
- En TEP de probabilidad baja/intermedia pedir antes dímero D; si es negativo no se requiere angioTAC.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 163

Paciente con dolor retroesternal irradiado a dorso que cedió, presión elevada, sudoración y pulsos distales débiles. ¿Cuál es el examen de elección?

A AngioTAC de tórax y abdomen
B Ecocardiografía transtorácica urgente
C Coronariografía urgente
D Radiografía de tórax anteroposterior
E Resonancia magnética cardíaca

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (AngioTAC de tórax y abdomen). AngioTAC de tórax y abdomen.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 55 años, operada de cadera hace 10 días, presenta disnea súbita y dolor pleurítico. FC 110 lpm, PA 125/80 mmHg, SatO2 91%. Score de Wells: 7,5 puntos. **¿Cuál es el examen a solicitar para confirmar el diagnóstico?**

A Dímero D
B Ecocardiograma transtorácico
C Radiografía de tórax
D AngioTAC de tórax
E Gases arteriales

Respuesta D. Con probabilidad clínica alta de TEP (Wells >6 o >4 según la versión) se solicita directamente angioTAC de tórax; el dímero D solo es útil para descartar en probabilidad baja/intermedia. Se debe anticoagular mientras se espera el examen.

▶ VER CLASE 1.01.4.003 Radiografía de tórax

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.2 · Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín

QUÉ HAY QUE SABER

- Lectura sistemática: técnica (PA vs AP, inspiración, rotación, penetración), partes blandas y huesos, mediastino, hilios, silueta cardíaca, parénquima, pleura y senos costofrénicos.
- Índice cardiotorácico >0,5 en PA indica cardiomegalia (no valorable en AP). Botellón: derrame pericárdico. Doble contorno y 4° arco: crecimiento de AI (estenosis mitral).
- Congestión por IC: redistribución de flujo a vértices, líneas B de Kerley, edema intersticial y alveolar en 'alas de mariposa', derrame pleural bilateral o derecho.
- Ensanchamiento mediastínico (>8 cm): disección o aneurisma aórtico, trauma; signo del 3 y muescas costales (Roesler): coartación aórtica.
- Neumonía: consolidación con broncograma aéreo; neumotórax: línea pleural sin trama distal; SDRA: infiltrados bilaterales sin cardiomegalia; derrame: borramiento del seno costofrénico (≥200 mL en PA).
- Hallazgos que obligan a acción urgente: neumotórax a tensión (desviación mediastínica), ensanchamiento mediastínico con dolor torácico, edema pulmonar agudo, neumoperitoneo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 70 años con antecedente de infarto antiguo consulta por disnea progresiva y ortopnea. La radiografía de tórax muestra índice cardiotorácico de 0,6, redistribución de flujo hacia los vértices, líneas B de Kerley y derrame pleural bilateral pequeño. **¿Cuál es la interpretación más probable de la radiografía?**

A Edema pulmonar cardiogénico por insuficiencia cardíaca
B Neumonía bilateral
C Síndrome de distrés respiratorio agudo
D Fibrosis pulmonar
E Derrame pleural tuberculoso

Respuesta A. Cardiomegalia (índice cardiotorácico sobre 0,5), redistribución de flujo a los vértices, líneas B de Kerley y derrame bilateral son signos clásicos de congestión por insuficiencia cardíaca. En el SDRA el edema es no cardiogénico: corazón de tamaño normal, sin redistribución ni líneas de Kerley y con infiltrados más periféricos.

▶ VER CLASE 1.01.4.005 Cintigrafía de perfusión miocárdica

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 2.1 · Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional

QUÉ HAY QUE SABER

- Cintigrafía de perfusión miocárdica (SPECT con tecnecio o talio): compara imágenes en estrés (ejercicio o fármaco: dipiridamol, adenosina, dobutamina) y en reposo.
- Indicación: sospecha de enfermedad coronaria cuando el test de esfuerzo no es interpretable (BCRI, marcapaso, HVI, digoxina, WPW, infradesnivel basal) o el paciente no puede caminar; estratificación de riesgo y viabilidad.
- Defecto reversible (hipoperfusión en estrés que normaliza en reposo) = isquemia; defecto fijo = necrosis/cicatriz. Isquemia extensa (>10% del VI) indica alto riesgo → coronariografía.
- Ventajas: mayor sensibilidad y especificidad que la ergometría; informa FEVI y territorio coronario comprometido.
- Contraindicaciones del estrés con dipiridamol/adenosina: asma o broncoespasmo activo, BAV avanzado; suspender cafeína y teofilinas 24 h antes. Evitar en embarazo.
- El médico general usa el informe: resultado de alto riesgo o isquemia significativa → derivar a cardiología para coronariografía.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 61

¿Cuál es el mejor examen para determinar si una insuficiencia cardiaca es de origen isquémico?

A Electrocardiograma
B Holter de electrocardiograma
C Contigrafia de perfusión miocárdica
D Ecografía bidimensional
E Test de esfuerzo

Respuesta C. D? La verdad es que tanto la Ecocardiografía, como la Cintigrafía de perfusión son útiles para determinar la etiología isquémica de una ICC. La Ecocadiografía verá zonas hipoquinéticas y necrosadas o fibrosadas. La cintigrafía verá las zonas que se isquemizan con la actividad física.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 66 años con dolor torácico de esfuerzo atípico. ECG de reposo: bloqueo completo de rama izquierda. Camina sin dificultad. **¿Cuál es el examen más adecuado para el estudio de isquemia?**

A Test de esfuerzo convencional
B Cintigrafía de perfusión miocárdica con estrés farmacológico
C Holter de ritmo de 24 horas
D Radiografía de tórax
E Troponina ultrasensible seriada

Respuesta B. El BCRI impide interpretar el segmento ST en el test de esfuerzo convencional. En ese caso se prefiere un examen de imagen; con BCRI se prefiere el estrés farmacológico con vasodilatador (dipiridamol/adenosina) para evitar defectos septales falsos positivos.

▶ VER CLASE 1.01.4.006 Ecocardiografía

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA

Cardiología 2.4 · Complicaciones Mecánicas del IAM & Angina de Prinzmetal
Cardiología 3.1 · Insuficiencia Cardíaca Crónica: Fenotipos, Diagnóstico & Criterios Framingham
Cardiología 4.1 · Estenosis Aórtica: Semiología, Severidad & TAVI vs SAVR (Guía GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Ecocardiograma transtorácico: examen de elección para evaluar estructura y función cardíaca; no invasivo, sin radiación. Transesofágico para prótesis, endocarditis, trombo en orejuela y aorta.
- Informa FEVI: reducida ≤40%, levemente reducida 41–49%, preservada ≥50%; trastornos segmentarios de motilidad (isquemia/infarto), hipertrofia (>11–12 mm) y dilatación de cavidades.
- Valvulopatías: área y gradientes; EAo severa (área <1 cm², gradiente medio ≥40 mmHg, velocidad ≥4 m/s); EM severa (área <1,5 cm²).
- Pericardio: derrame y signos de taponamiento (colapso diastólico de AD/VD). Estima PSAP (hipertensión pulmonar si >35–40 mmHg) y función del VD (TEP, cor pulmonale).
- Indicaciones: IC, soplo patológico, síncope de esfuerzo, FA, post IAM, sospecha de endocarditis (vegetaciones), cardiopatía congénita, HTA con sospecha de HVI.
- El médico general solicita e integra el informe; derivar a cardiología ante FEVI reducida, valvulopatía significativa, derrame importante o vegetaciones.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 53

Paciente de 67 años, con antecedentes de infarto agudo al miocardio hace 6 meses tratado con stent, hipertensión arterial tratada con enalapril e hidroclorotiazida, y diabetes mellitus tratada con insulina horaria, consulta por cuadro de dos meses de disnea de medianos esfuerzos, asociado a ortopnea y edema de extremidades inferiores que aumenta en las tardes. Al examen cardiopulmonar destaca ritmo regular en dos tiempos sin soplos y murmullo pulmonar presente con crepitaciones bibasales. ¿Cuál de los siguientes es el examen de elección para iniciar el estudio diagnóstico?

A Electrocardiograma
B Coronariografía
C Test de esfuerzo
D Radiografía de torax
E Ecocardiograma

Respuesta E. Tiene una insuficiencia cardiaca, secundaria a cardiopatía coronaria. Hay que pedir la Ecocardiografía, para ver la función ventricular.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 70 años con disnea de esfuerzo progresiva, edema de extremidades y crépitos basales. NT-proBNP 2.400 pg/mL. Ecocardiograma: FEVI 32%, VI dilatado, hipocinesia difusa, sin valvulopatías significativas. **¿Cómo se clasifica su insuficiencia cardíaca según el ecocardiograma?**

A IC con FEVI preservada
B IC con FEVI levemente reducida
C Miocardiopatía hipertrófica
D Disfunción diastólica aislada
E IC con FEVI reducida

Respuesta E. Una FEVI ≤40% define IC con fracción de eyección reducida, el fenotipo con tratamiento que reduce mortalidad (ARNI/IECA, betabloqueador, antialdosterónico e iSGLT2). FEVI 41–49% es levemente reducida y ≥50% preservada.

▶ VER CLASE 1.01.4.007 Electrocardiograma

NIVEL **REALIZA, INTERPRETA Y EMPLEA**

DÓNDE SE ENSEÑA

Cardiología 1.1 · Lectura Sistemática del ECG en Urgencias y APS
Cardiología 2.3 · SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES
Nefrología 3.1 · Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana

QUÉ HAY QUE SABER

- Lectura sistemática: ritmo, frecuencia (300/nº cuadros grandes), eje (DI y aVF), onda P, PR (120–200 ms), QRS (<120 ms), QT corregido (<450 ms H, <460 M), ST y onda T.
- Isquemia/IAM: supradesnivel ST ≥1 mm en 2 derivaciones contiguas (≥2 mm en V2–V3 hombres) = SCACEST; localización: inferior DII-DIII-aVF (coronaria derecha), anterior V1–V4 (descendente anterior), lateral DI-aVL-V5-V6 (circunfleja); V4R en IAM inferior.
- Hiperkalemia: T alta y picuda → PR largo y P aplanada → QRS ancho → onda sinusoidal/FV. Hipokalemia: T plana, onda U, QT largo.
- Arritmias: FA (irregular sin P), flutter (dientes de sierra), BAV (ver relación P-QRS), TV (QRS ancho regular); WPW (PR corto + onda delta). Pericarditis: ST cóncavo difuso + PR deprimido.
- HVI: Sokolow-Lyon (S V1 + R V5/V6) ≥35 mm; BCRD: rSR' en V1 con QRS ≥120 ms; BCRI: QRS ancho con R mellada en V6 (impide valorar isquemia).
- Técnica: V1–V2 en 4° espacio paraesternal, V4 en 5° espacio línea medioclavicular, V3 entre ambas, V5–V6 a la misma altura en líneas axilares anterior y media; realizar ECG en <10 min ante dolor torácico.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 180

Un paciente de 70 años, sin antecedentes de importancia presenta un síncope de reposo sin pródromo, con recuperación completa. Al examen físico se encuentra orientado, en Glasgow 15, con frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?**

A Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas
B Ecocardiograma
C TAC de cerebro
D Resonancia magnética de cerebro
E Electrocardiograma

Respuesta E. Síncope de reposo, sin pródromos y con bradicardia: sospecha de síncope cardiogénico por bradiarritmia. El examen inicial es el electrocardiograma de 12 derivaciones, que puede mostrar bloqueos AV o enfermedad del nodo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 180

Un paciente de 70 años, sin antecedentes de importancia, presenta un síncope de reposo sin pródromo, con recuperación completa. Al examen físico se encuentra orientado, con Glasgow 15 y frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?**

A Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas

B Ecocardiograma

C TAC de cerebro

D Resonancia magnética de cerebro

E Electrocardiograma

Respuesta E. Síncope sin pródromo, en reposo y con bradicardia sugiere causa cardíaca arrítmica. El ECG de 12 derivaciones es el examen inicial: muestra bloqueos AV, disfunción sinusal y signos de trastornos electrolíticos como la hiperkalemia. El Holter se pide si el ECG no es concluyente.

▶ VER CLASE 1.01.4.008 Test de esfuerzo

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 2.1 · Angina Crónica Estable & Estratificación de Riesgo Funcional

QUÉ HAY QUE SABER

- Ergometría (test de esfuerzo en cinta, protocolo de Bruce): examen inicial para diagnóstico y estratificación de enfermedad coronaria en pacientes que pueden caminar y con ECG basal interpretable.
- Positivo: infradesnivel ST horizontal o descendente ≥1 mm a 80 ms del punto J, o angina típica durante el esfuerzo. Se considera válido si alcanza ≥85% de la FC máxima teórica (220 – edad).
- Alto riesgo: infradesnivel ≥2 mm, positivo en etapa 1, caída de la PAS con el esfuerzo, arritmias ventriculares o duración prolongada de la depresión del ST → coronariografía.
- Contraindicaciones: SCA reciente (<48 h), estenosis aórtica severa sintomática, IC descompensada, arritmias no controladas, disección aórtica, TEP o miopericarditis aguda.
- No interpretable con ECG basal alterado (BCRI, marcapaso, WPW, HVI con alteración de repolarización, digoxina): preferir imagen (cintigrafía o eco de estrés).
- También evalúa capacidad funcional, respuesta presora y cronotrópica y orienta la prescripción de ejercicio y rehabilitación cardíaca.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 85

Paciente de 57 años, hipertenso en tratamiento con losartan y tabáquico, consulta por historia de 3 semanas de evolución de episodios caracterizados por dolor torácico que aparece al caminar por más de 10 minutos, el cual tiene una duración máxima de 5 minutos y luego cede al reposo, no asociado a otros síntomas. Actualmente se encuentra asintomático y su examen físico es normal. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para iniciar su estudio?

A Radiografía de tórax

B Ecocardiograma

C Coronariografía

D Electrocardiograma

E Test de esfuerzo

Respuesta E. Es una angina de esfuerzo. Si bien hay que pedir un ECG, el TE es el examen para la angina en sí. Además el test de esfuerzo es un ECG y si está malo al inicio, no se prosigue con el examen. En la vida real, sí se pedirá probablemente el ECG, pero se debe simplificar la pregunta, a ¿cómo se estudia una angina estable?.. con Test d esfuerzo. Si viniera con soplo, se sospecharía una estenosis aórtica y la respuesta sería Ecografía.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años con angina de esfuerzo. En el test de esfuerzo presenta, en el primer estadio del protocolo de Bruce, angina típica, infradesnivel horizontal del ST de 2,5 mm en V4–V6 y descenso de la presión sistólica de 20 mmHg. **¿Cuál es la interpretación y conducta?**

A Test negativo; control anual

B Test positivo de bajo riesgo; iniciar betabloqueador y control

C Test positivo de alto riesgo; derivar para coronariografía

D Test no concluyente; repetir en 6 meses

E Test positivo; indicar trombolisis

Respuesta C. Infradesnivel ≥2 mm, positividad en el primer estadio y caída de la PAS con el esfuerzo son criterios de alto riesgo (sugieren enfermedad de tronco o multivaso), por lo que corresponde coronariografía.

▶ VER CLASE 1.01.4.009 Enzimas cardíacas (CPK, MB, LDH, troponinas)

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 2.2 · SCASEST: Angina Inestable e IAM sin Supradesnivel del ST

QUÉ HAY QUE SABER

- Troponina T o I (ultrasensible): marcador de elección de daño miocárdico; sube a las 2–4 h, peak a las 24 h y persiste 7–14 días. IAM: elevación sobre el percentil 99 con curva de ascenso/descenso + contexto isquémico.
- Protocolo rápido: troponina ultrasensible a las 0 y 1–3 h; un valor normal muy precoz (<3 h del inicio del dolor) no descarta infarto y debe repetirse.

- CK-MB: sube a las 4–6 h y se normaliza a las 48–72 h; útil para detectar reinfarto. CK total también sube en daño muscular esquelético (rabdomiólisis, ejercicio, IM). LDH: tardía e inespecífica, en desuso.
- Troponina elevada sin SCA: miocarditis, TEP, IC, sepsis, ERC, taquiarritmias, disección aórtica, contusión miocárdica, ACV.
- Angina inestable: troponinas normales; IAM sin SDST: troponinas elevadas sin supradesnivel. En IAM con SDST no esperar troponinas para reperfundir.
- Interpretar siempre junto a la clínica y el ECG; la magnitud de la elevación se asocia al tamaño del infarto y al pronóstico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 2.2

Hombre de 64 años con dolor torácico opresivo de reposo prolongado ingresa a urgencias. El ECG muestra infradesnivel del ST de 2 mm en derivaciones DII, DIII y aVF. Troponinas ultrasensibles positivas. ¿Cuál es el esquema antitrombótico inicial más adecuado mientras se programa la coronariografía?

A Aspirina 250 mg + Ticagrelor 180 mg + Enoxaparina 1 mg/kg subcutánea

B Aspirina 100 mg en monoterapia oral

C Trombólisis con Tenecteplase endovenoso inmediato

D Heparina no fraccionada en infusión sin antiagregantes plaquetarios

E Acenocumarol oral para alcanzar INR de 2.5

Respuesta A. El pilar farmacológico del SCASEST confirmado es la triple terapia antitrombótica inicial: doble antiagregación plaquetaria (Aspirina + Ticagrelor) asociada a anticoagulación parenteral (Enoxaparina). La trombólisis farmacológica está formalmente CONTRAINDICADA en el SCASEST (solo se usa en SCACEST con supradesnivel del ST).

▶ VER CLASE 1.01.4.010 Hemograma y velocidad de hemosedimentación (VHS)

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.21 · Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemograma: serie roja (Hb, VCM: microcítica ferropriva/talasemia, macrocítica B12/folato/alcohol/hipotiroidismo), blanca (leucocitosis con desviación izquierda en infección bacteriana) y plaquetas.
- Anemia: Hb <13 g/dL en hombres, <12 en mujeres no embarazadas y <11 en embarazadas; puede descompensar angina o IC.
- Neutropenia <1.500/µL (grave <500); linfocitosis en virosis; eosinofilia en parasitosis, alergias y fármacos; pancitopenia o blastos → derivar a hematología.
- VHS: reactante de fase aguda inespecífico; normal aproximadamente edad/2 en hombres y (edad+10)/2 en mujeres. Sube en infecciones, neoplasias, mieloma, anemia y embarazo.
- VHS muy elevada (>50–100 mm/h): arteritis de células gigantes y polimialgia reumática (iniciar corticoides sin esperar biopsia si hay síntomas visuales), mieloma, endocarditis, osteomielitis.
- En cardiología: VHS/PCR elevadas apoyan fiebre reumática (criterio menor de Jones), pericarditis y endocarditis.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 74 años consulta por cefalea temporal derecha de 3 semanas, claudicación mandibular y malestar general. Tiene la arteria temporal engrosada y dolorosa. Hemograma: hemoglobina 10,8 g/dL normocítica, plaquetas 480.000/mm³. **¿Qué resultado de laboratorio apoya con mayor fuerza la sospecha diagnóstica?**

A Eosinofilia de 15%

B Leucopenia con linfocitosis

C VHS de 95 mm/h

D VHS de 8 mm/h

E Policitemia

Respuesta C. Cefalea temporal, claudicación mandibular y arteria temporal engrosada en mayor de 50 años sugieren arteritis de células gigantes. Una VHS muy elevada (habitualmente sobre 50 mm/h) la apoya, junto a anemia de enfermedad crónica y trombocitosis; una VHS normal la hace improbable. Se inicia prednisona sin esperar la biopsia.

▶ VER CLASE 1.01.4.011 Holter de presión arterial

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 5.1 · Hipertensión Arterial Esencial & Secundaria: Diagnóstico, Metas GES & Terapia Dual

QUÉ HAY QUE SABER

- MAPA (monitoreo ambulatorio de PA de 24 h): mediciones automáticas cada 15–30 min durante actividades habituales y el sueño.
- Valores diagnósticos de HTA: promedio de 24 h ≥130/80 mmHg, vigilia ≥135/85, sueño ≥120/70 mmHg.
- Indicaciones: sospecha de HTA de delantal blanco (PA alta en consulta sin daño de órgano), HTA enmascarada (normal en consulta con daño de órgano), HTA resistente, hipotensión sintomática por fármacos, HTA en embarazo y evaluación del patrón nocturno.
- Patrón dipper normal: descenso nocturno de 10–20%; non-dipper (<10%) o riser asocian mayor riesgo cardiovascular y sugieren SAHOS, ERC o HTA secundaria.
- HTA de delantal blanco: no requiere fármacos si no hay daño de órgano ni alto riesgo, pero sí control periódico y estilo de vida.

- El médico general emplea el informe para confirmar el diagnóstico y ajustar el tratamiento; alternativa válida es la automedición domiciliaria estandarizada (≥135/85 = HTA).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 55 años tiene presiones en la consulta de 152/94 y 148/92 mmHg en dos controles, pero refiere que en la farmacia y en su casa sus mediciones son de 120/78 mmHg. No tiene daño de órgano blanco. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A Ecocardiograma

B Monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas (MAPA)

C Holter de ritmo

D Prueba de esfuerzo

E Fondo de ojo

Respuesta B. Ante sospecha de hipertensión de bata blanca (PA alta en consulta y normal fuera de ella), el MAPA de 24 horas es el estándar para confirmar o descartar hipertensión: un promedio de 24 horas bajo 130/80 mmHg la descarta. También detecta hipertensión enmascarada y ausencia de descenso nocturno.

▶ VER CLASE 1.01.4.012 Perfil bioquímico

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.1 · Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Perfil bioquímico: glicemia, BUN/urea, creatinina, ácido úrico, calcio, fósforo, proteínas totales, albúmina, colesterol, bilirrubina, fosfatasas alcalinas, transaminasas (GOT/GPT), LDH.
- Patrón hepatocelular: transaminasas muy elevadas (GPT > GOT en hepatitis viral; GOT/GPT >2 en hepatopatía alcohólica). Patrón colestásico: fosfatasas alcalinas y GGT elevadas con bilirrubina directa.
- Función renal: creatinina para estimar VFG (CKD-EPI); BUN/creatinina >20 sugiere causa prerrenal o hemorragia digestiva alta.
- Calcio: corregir por albúmina (Ca + 0,8 × [4 – albúmina]); hipercalcemia por hiperparatiroidismo o neoplasia. Hipoalbuminemia en desnutrición, síndrome nefrótico o daño hepático crónico.
- Ácido úrico elevado en gota, ERC, diuréticos tiazídicos y síndrome de lisis tumoral; glicemia en ayunas ≥126 mg/dL en 2 ocasiones diagnostica DM.
- En cardiología: necesario al iniciar IECA/ARA-II/diuréticos/espironolactona (función renal y electrolitos) y para monitorizar estatinas (transaminasas).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 72 años, asintomático, tiene en su perfil bioquímico fosfatasa alcalina de 420 U/L (normal hasta 120), con GGT, bilirrubina, transaminasas, calcio y fósforo normales. Refiere dolor leve en la tibia derecha, que se ve arqueada. **¿Cuál es el origen más probable de la elevación de la fosfatasa alcalina?**

A Colestasia intrahepática

B Obstrucción de la vía biliar

C Hepatitis aguda

D Origen óseo, sugerente de enfermedad de Paget

E Metástasis hepáticas

Respuesta D. La fosfatasa alcalina proviene de hígado y hueso; si la GGT es normal, el origen es óseo. En un adulto mayor con fosfatasa alcalina aislada, calcio normal y tibia arqueada, sugiere enfermedad de Paget, que se confirma con radiografías y cintigrama óseo. La colestasia elevaría también la GGT.

▶ VER CLASE 1.01.4.013 Perfil lipídico

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.4 · Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

QUÉ HAY QUE SABER

- Componentes: colesterol total, HDL, triglicéridos y LDL calculado por Friedewald (LDL = CT – HDL – TG/5), no válido si TG >400 mg/dL; colesterol no-HDL = CT – HDL (meta = meta LDL + 30).
- Valores deseables: CT <200 mg/dL, TG <150, HDL ≥40 en hombres y ≥50 en mujeres; LDL según riesgo cardiovascular (<55–70 en alto riesgo, <100 moderado, <130 bajo).
- LDL ≥190 mg/dL: sospechar hipercolesterolemia familiar (xantomas tendinosos, historia familiar de enfermedad coronaria precoz) → estatina de alta intensidad y estudio familiar.
- TG ≥500 mg/dL (sobre todo ≥1000): riesgo de pancreatitis aguda → fibrato y control de alcohol/azúcares/DM.
- Ayuno de 9–12 h recomendado si se sospecha hipertrigliceridemia; descartar causas secundarias (hipotiroidismo, DM, síndrome nefrótico, colestasia, alcohol, fármacos).
- Control: 6–12 semanas tras iniciar o ajustar estatina y luego cada 6–12 meses; tamizaje en el EMPA desde los 40 años o antes si hay factores de riesgo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 50 años se realiza un perfil lipídico con 12 horas de ayuno: colesterol total 260 mg/dL, HDL 40 mg/dL y triglicéridos 600 mg/dL. El laboratorio no informa el LDL calculado. **¿Por qué no se informa el colesterol LDL?**

A Porque el ayuno fue insuficiente

B Porque el LDL solo se mide en diabéticos

C Porque el HDL es bajo

D Porque el colesterol total es normal

E Porque la fórmula de Friedewald no es válida con triglicéridos sobre 400 mg/dL

Respuesta E. El LDL suele calcularse con Friedewald: LDL = CT − HDL − TG/5. Con triglicéridos sobre 400 mg/dL la fórmula pierde validez y se mide el LDL directo o se usa el colesterol no-HDL (CT − HDL), aquí 220 mg/dL. Con TG sobre 500, la prioridad es bajarlos para prevenir pancreatitis.

▶ VER CLASE **1.01.4.014** **Holter de ritmo** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 1.6 · Extrasístoles Ventriculares Benignas y Holter de Ritmo

QUÉ HAY QUE SABER

- Holter de ritmo: registro ECG continuo de 24–48 h (o más días con monitores de eventos) durante actividades habituales con diario de síntomas.
- Indicaciones: palpitaciones, síncope o presíncope no explicados, sospecha de FA paroxística (incluido estudio de ACV criptogénico), cuantificar extrasistolía y evaluar respuesta a antiarrítmicos o control de frecuencia en FA.
- Correlacionar síntomas con el ritmo: síntoma sin arritmia orienta a causa no arrítmica; arritmia sin síntoma puede ser hallazgo.
- Hallazgos de alarma: pausas >3 s en vigilia, BAV 2° Mobitz II o 3°, TV sostenida o no sostenida frecuente, FA paroxística → derivar a cardiología.
- Carga de extrasístoles ventriculares >10–20% se asocia a miocardiopatía inducida; bradicardia sinusal nocturna y BAV 1° o Wenckebach nocturnos pueden ser fisiológicos.
- Si los síntomas son infrecuentes (mensuales), el Holter de 24 h tiene bajo rendimiento: preferir monitor de eventos o Holter implantable.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 7

Una paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial y fibrilación auricular, en tratamiento con atenolol, verapamilo y acenocumarol, consulta porque presenta repetidos episodios de malestar, sudoración y ortostatismo, que duran algunos segundos y revierten espontáneamente. Al examen físico destaca frecuencia cardíaca de 60 por minuto, irregular, y presión arterial 110/70 mmHg. Su examen cardiopulmonar es normal. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?**

A Test de esfuerzo

B Ecocardiograma

C Ecografía doppler de extremidades inferiores

D Tilt test

E Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas

Respuesta E. Episodios presincopales breves y recurrentes en una paciente con fibrilación auricular y dos frenadores del nodo (atenolol más verapamilo, combinación riesgosa) sugieren bradiarritmia: pausas o síndrome taquicardia-bradicardia. El Holter de 24 horas correlaciona síntomas con el ritmo. El tilt test estudia el síncope vasovagal.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

8 códigos

▶ VER CLASE **1.01.5.002** **Cardioversión eléctrica** NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 1.4 · TPSV & Síndrome de Wolff-Parkinson-White

QUÉ HAY QUE SABER

- Cardioversión eléctrica sincronizada: descarga coincidente con la onda R para evitar caer en período vulnerable (fenómeno R sobre T → FV).
- Urgente en toda taquiarritmia con pulso e inestabilidad (hipotensión, shock, dolor isquémico, IC aguda, compromiso de conciencia): FA 120–200 J bifásico, flutter y TPSV 50–100 J, TV monomorfa con pulso 100 J.
- Electiva en FA o flutter estables: requiere anticoagulación ≥3 semanas antes (o ETE sin trombo) si duran >48 h o tiempo incierto, y 4 semanas después en todos.
- Preparación: ayuno, consentimiento, sedación breve (midazolam, propofol o etomidato), monitorización y equipo de vía aérea; corregir hipokalemia y descartar intoxicación digitálica.
- No sincronizar en FV o TV sin pulso (desfibrilación); no es útil en taquicardia sinusal ni taquicardia auricular multifocal.
- El médico general deriva al especialista la cardioversión electiva; en urgencia vital con inestabilidad debe realizarla sin demora.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 70 años con FA de 5 días de evolución, en buenas condiciones, PA 130/80 mmHg y FC 100 lpm. Sin anticoagulación previa. Se plantea restablecer el ritmo sinusal mediante cardioversión eléctrica electiva. **¿Cuál es el requisito previo más importante?**

A Anticoagular al menos 3 semanas antes o descartar trombo con ecocardiograma transesofágico

B Realizar la cardioversión inmediatamente sin más estudio

C Administrar digoxina EV antes de la descarga

D Usar descarga no sincronizada de 360 J

E Suspender toda anticoagulación después del procedimiento

Respuesta A. En FA >48 horas, cardiovertir sin anticoagulación previa expone a embolía al restablecer la contracción auricular. Se anticoagula 3 semanas antes (o ETE sin trombo) y al menos 4 semanas después; la descarga debe ser sincronizada.

▶ VER CLASE 1.01.5.003 Cateterismo venoso central

NIVEL **DERIVAR A ESPECIALISTA**

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 2.3 · IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: administración de drogas vasoactivas, nutrición parenteral, quimioterapia o soluciones irritantes, monitorización de PVC, hemodiálisis de urgencia, ausencia de acceso periférico.
- Accesos: yugular interna (preferida con ecografía), subclavia (menor infección, mayor riesgo de neumotórax) y femoral (más infección y trombosis, útil en paro).
- Técnica de Seldinger con barreras máximas (gorro, mascarilla, delantal, guantes estériles, campo amplio), antisepsia con clorhexidina y guía ecográfica.
- Complicaciones: neumotórax, punción arterial, hematoma, arritmias, embolía gaseosa, trombosis e infección del torrente sanguíneo (IAAS). Rx de tórax post instalación (yugular/subclavia) para posición y descartar neumotórax.
- Prevención de infección asociada a catéter: indicación diaria de necesidad, retirar lo antes posible, curaciones con técnica aséptica; fiebre sin foco en portador → hemocultivos central y periférico.
- El médico general conoce indicaciones y complicaciones y lo deriva al especialista (intensivista, anestesista o cirujano) para su instalación.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Se instala un catéter venoso central por vía subclavia derecha a un paciente de 60 años en UCI. A los 20 minutos presenta disnea súbita, taquicardia y saturación de 88%, con murmullo pulmonar abolido en el hemitórax derecho. **¿Cuál es la complicación más probable?**

A Neumotórax iatrogénico

B Embolia gaseosa

C Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter

D Trombosis venosa asociada al catéter

E Arritmia por catéter en el ventrículo

Respuesta A. La punción subclavia es la vía con mayor riesgo de neumotórax. Disnea, desaturación y murmullo abolido ipsilateral tras la instalación lo sugieren; por eso siempre se toma radiografía de tórax post procedimiento, que además verifica la punta del catéter. La infección asociada a catéter aparece días después, no a los minutos.

▶ VER CLASE 1.01.5.004 Desfibrilación

NIVEL **REALIZAR**

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 1.2 · Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

QUÉ HAY QUE SABER

- Desfibrilación: descarga eléctrica NO sincronizada; único tratamiento eficaz de la FV y TV sin pulso. Cada minuto de retraso reduce la sobrevida ~7–10%.
- Energía: bifásico 120–200 J según fabricante (o máxima), monofásico 360 J; con DEA seguir las instrucciones del equipo.
- Posición de las paletas: esternal (bajo la clavícula derecha) y apical (línea axilar media izquierda, 5° espacio); alternativa anteroposterior. Evitar parches de nitroglicerina y alejarse ≥8 cm de marcapasos.
- Seguridad: anunciar la descarga, nadie en contacto con el paciente, retirar el O2 del tórax; secar el tórax si está mojado.
- Tras la descarga reanudar inmediatamente compresiones por 2 minutos sin revisar pulso; adrenalina tras la 2ª descarga y amiodarona 300 mg tras la 3ª.
- No desfibrilar asistolia ni AESP; los DEA en lugares públicos (Ley 21.156 de Chile) permiten desfibrilación precoz por legos.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 1.2

Durante la reanimación cardiopulmonar avanzada de una mujer de 50 años en fibrilación ventricular, se realiza la primera descarga de 200 J bifásicos. ¿Cuál es la acción inmediata que debe realizar el equipo?

A Reanudar inmediatamente las compresiones torácicas durante 2 minutos antes de cualquier otra evaluación

B Palpar el pulso carotídeo para verificar si recuperó circulación espontánea

C Mirar el monitor para comprobar si el ritmo cambió a sinusal

D Administrar inmediatamente 1 mg de adrenalina endovenosa

E Administrar 300 mg de amiodarona en bolo rápido

Respuesta A. La regla de oro del ACLS establece que inmediatamente después de administrar una descarga eléctrica, se deben reanudar las compresiones torácicas durante 2 minutos completos sin interrumpir para verificar el ritmo o el pulso. Chequear el pulso inmediatamente después del choque genera pausas innecesarias y el corazón recién desfibrilado requiere soporte hemodinámico mediante compresiones para recuperar el gasto cardíaco.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 4

Un paciente de 64 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial mal controlados, consulta en el servicio de urgencia por dolor torácico opresivo EVA 9/10, asociado a disnea y malestar general. Durante su atención presenta un electrocardiograma que muestra a continuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Cardioversión eléctrica

B Desfibrilación eléctrica

C Amiodarona endovenosa

D Maniobras de reanimación cardiopulmonar

E Coronariogra:a urgente

Respuesta B. El ECG corresponde a un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST (cara inferior), que evoluciona a fibrilación ventricular, lo que constituye un paro cardíaco presenciado en ritmo desfibrilable (fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso). Por ser un paro presenciado, la conducta inmediata es la desfibrilación eléctrica. Las maniobras de RCP se inician de forma simultánea, pero no reemplazan la desfibrilación precoz. La cardioversión se realiza en las taquiarritmias...

▶ VER CLASE 1.01.5.005 Intubación traqueal

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: incapacidad de proteger la vía aérea (Glasgow ≤8), insuficiencia respiratoria refractaria, paro cardiorrespiratorio sin ventilación eficaz con bolsa, shock grave, quemadura de vía aérea u obstrucción inminente.
- Preparación: preoxigenar con O2 100% por 3–5 min, posición de olfateo, equipo (laringoscopio, tubos 7–8 en mujeres y 8–8,5 en hombres, guía, aspiración, bolsa-mascarilla, capnógrafo) y vía venosa.
- Secuencia de intubación rápida: inductor (etomidato 0,3 mg/kg, ketamina 1–2 mg/kg o propofol) + relajante (succinilcolina 1–1,5 mg/kg o rocuronio 1–1,2 mg/kg).
- Confirmación: capnografía (gold standard), visualización del paso por cuerdas, auscultación bilateral simétrica y epigastrio silente; Rx de tórax (punta 2–4 cm sobre la carina). Fijar a 21–23 cm en la comisura.
- En trauma: inmovilización cervical manual en línea; si falla la intubación y no se puede ventilar: dispositivo supraglótico o cricotiroidotomía.
- Complicaciones: intubación esofágica o selectiva derecha (hipoventilación izquierda), hipoxemia, broncoaspiración, trauma dental o laríngeo, hipotensión post inducción. Succinilcolina contraindicada en hiperkalemia, quemados/aplastamiento >24 h y neuromusculares.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un motociclista de 25 años ingresa tras un choque. Tiene Glasgow de 7 (O1 V2 M4), respiración ruidosa y saturación de 90% con mascarilla de alto flujo. Se mantiene la restricción de movimiento cervical. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la vía aérea?**

A Mantener la mascarilla de alto flujo y realizar TAC de encéfalo

B Intubación orotraqueal con secuencia rápida, manteniendo la restricción del movimiento cervical

C Cánula nasofaríngea y observación

D Traqueostomía electiva

E Ventilación no invasiva

Respuesta B. Un Glasgow de 8 o menos indica incapacidad de proteger la vía aérea y es indicación de vía aérea definitiva. En trauma se realiza intubación orotraqueal con secuencia rápida y restricción del movimiento cervical en línea. La ventilación no invasiva está contraindicada con compromiso de conciencia; la vía quirúrgica se reserva si falla la intubación.

▶ VER CLASE 1.01.5.006 Resucitación cardiorespiratoria

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 1.2 · Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

QUÉ HAY QUE SABER

- Cadena de sobrevida: reconocer el paro, activar emergencia (131) y pedir DEA, RCP precoz, desfibrilación precoz, soporte vital avanzado y cuidados post-paro.
- Adultos: si no responde y no respira normalmente, iniciar compresiones de inmediato (C-A-B); centro del tórax, 100–120/min, 5–6 cm, reexpansión completa, interrupciones <10 s.
- Relación 30:2 sin vía aérea avanzada; con tubo o dispositivo supraglótico, compresiones continuas y 1 ventilación cada 6 s (10/min). Legos no entrenados: solo compresiones.
- Conectar el DEA/monitor lo antes posible: FV/TV sin pulso → descarga; asistolia/AESP → RCP + adrenalina 1 mg c/3–5 min; buscar 5H y 5T.
- Pediatría: compresiones 1/3 del diámetro anteroposterior, relación 30:2 con un reanimador y 15:2 con dos; en niños el paro suele ser de causa respiratoria.
- Finalizar según criterio clínico (asistolia prolongada sin causa reversible, capnografía persistentemente <10 mmHg tras 20 min de RCP avanzada); post-paro: SatO2 92–98%, PAM ≥65, control de temperatura y coronariografía si hay SDST.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 158

Un paciente de 67 años, diabético, hipertenso y dislipidémico, fumador activo, consulta en el servicio de urgencia por dolor torácico opresivo e intenso, de 2 horas de evolución, irradiado al hombro derecho y asociado a disnea. Mientras estaba en la sala de reanimación presenta pérdida de conciencia y usted constata que no se mueve, no respira y no tiene pulso. Además de pedir ayuda y activar el código de paro, ¿cuál es la conducta inmediata?

A Instalar el monitor cardíaco en modo paletas

B Realizar intubación orotraqueal

C Solicitar electrocardiograma

D Realizar compresiones torácicas

E Administrar adrenalina endovenosa en bolo

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar compresiones torácicas (opción D).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En el pasillo del hospital usted encuentra a un hombre de 55 años tendido en el suelo. No responde al estímulo y solo presenta respiraciones agónicas. Ya pidió ayuda y que traigan el desfibrilador. **¿Cuál es la acción inmediata siguiente?**

A Dar 5 ventilaciones de rescate antes de comprimir

B Buscar pulso carotídeo durante 30 segundos

C Colocar al paciente en posición lateral de seguridad

D Iniciar compresiones torácicas a 100–120 por minuto

E Esperar el desfibrilador para decidir la conducta

Respuesta D. Un paciente que no responde y respira de forma agónica está en paro: se deben iniciar compresiones de alta calidad de inmediato, sin buscar pulso por más de 10 segundos. Las respiraciones agónicas no son respiración normal; la posición lateral es para pacientes que respiran.

▶ VER CLASE **1.01.5.007** **Punción pericárdica** NIVEL **DERIVAR A ESPECIALISTA**

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 5.3 · Pericarditis Aguda & Taponamiento Cardíaco

QUÉ HAY QUE SABER

- Pericardiocentesis: punción del saco pericárdico para drenaje; indicación urgente en taponamiento cardíaco (tríada de Beck, pulso paradójico, colapso de cavidades derechas en eco).
- Indicación diagnóstica: derrame de causa no aclarada (sospecha bacteriana, tuberculosa o neoplásica) con estudio citoquímico, cultivo, ADA y citología del líquido.
- Técnica: vía subxifoidea dirigiendo la aguja hacia el hombro izquierdo en 30–45°, idealmente guiada por ecocardiografía, con monitorización ECG; dejar catéter de drenaje.
- Complicaciones: punción ventricular o coronaria, arritmias, neumotórax, lesión hepática, edema pulmonar por descompresión e infección.
- Contraindicaciones: disección aórtica con hemopericardio (requiere cirugía), rotura de pared libre post IAM; relativas: coagulopatía, derrame pequeño o posterior o loculado.
- El médico general reconoce la indicación y deriva al especialista; en paro por taponamiento sin especialista disponible, la punción es salvadora.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 62 años con cáncer pulmonar avanzado consulta por disnea progresiva. PA 82/60 mmHg, FC 120 lpm, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados y caída de la PAS de 15 mmHg en inspiración. Ecocardiograma: derrame pericárdico severo con colapso diastólico del ventrículo derecho. **¿Cuál es el tratamiento inmediato?**

A Furosemida 40 mg EV

B Pericardiocentesis descompresiva

C Nitroglicerina en infusión EV

D Ibuprofeno y colchicina

E Dobutamina como única medida

Respuesta B. Hipotensión, ingurgitación yugular, ruidos apagados y pulso paradójico con colapso del VD configuran un taponamiento cardíaco: requiere pericardiocentesis urgente. Diuréticos y vasodilatadores reducen la precarga y pueden precipitar un colapso hemodinámico.

▶ VER CLASE 1.01.5.008 Punción venosa

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.21 · Procedimientos de Cirugía Menor: Punción Venosa, Manejo de Drenajes, Onicocriptosis & Onicectomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: toma de muestras de sangre e instalación de vía venosa periférica para fluidos, fármacos y hemoderivados.
- Sitios: venas del dorso de la mano y antebrazo (cefálica, basílica); fosa antecubital para muestras. Evitar extremidad con fístula AV, linfedema o mastectomía homolateral, zonas infectadas o con flebitis.
- Técnica: lavado de manos y guantes, ligadura 7–10 cm proximal, antisepsia (alcohol 70% o clorhexidina) dejando secar, punción con bisel hacia arriba en 15–30°, retirar ligadura antes de sacar la aguja y comprimir.
- Calibre: 14–16 G en reanimación y trauma (2 vías gruesas), 18–20 G para uso habitual, 22–24 G en ancianos y niños.
- Complicaciones: hematoma, flebitis (cambiar el catéter cada 72–96 h o ante signos), extravasación, infección, punción arterial accidental.
- Orden de tubos para extracción: hemocultivos primero, luego citrato (coagulación), suero, heparina, EDTA (hemograma) y fluoruro (glicemia).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 62 años, con antecedente de mastectomía izquierda con disección axilar por cáncer de mama, requiere toma de exámenes de sangre. **¿Cuál es la indicación más adecuada para la punción venosa?**

A Puncionar el brazo izquierdo, porque tiene venas más visibles

B Mantener el torniquete apretado más de 3 minutos para facilitar la punción

C Puncionar el brazo derecho, evitando el brazo con disección axilar

D Retirar la aguja antes de soltar el torniquete

E Puncionar siempre la vena femoral

Respuesta C. Se evita puncionar la extremidad con disección axilar (riesgo de linfedema e infección), con fístula arteriovenosa o con una vía venosa en curso. El torniquete debe mantenerse menos de 1 minuto para no alterar resultados (hemoconcentración, potasio) y soltarse antes de retirar la aguja, para evitar hematomas.

▶ VER CLASE 1.01.5.009 Trombolisis

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 2.3 · SCACEST: IAM con Supradesnivel del ST & Protocolo Reperfusión GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: IAM con supradesnivel ST (o BCRI nuevo) de <12 h de evolución cuando la angioplastía primaria no se puede realizar en <120 min desde el diagnóstico; meta puerta-aguja <30 min (GES).
- Fármacos: tenecteplase en bolo único EV ajustado a peso (30–50 mg; 6.000 a 10.000 UI) o estreptoquinasa 1,5 millones UI en 60 min; asociar aspirina, clopidogrel y enoxaparina.
- Contraindicaciones absolutas: ACV hemorrágico previo, ACV isquémico <3 meses, neoplasia o malformación intracraneal, sangrado activo, sospecha de disección aórtica, TEC o cirugía mayor reciente (<3 semanas).
- Relativas: HTA no controlada (>180/110), anticoagulación oral, embarazo, RCP traumática o prolongada, úlcera péptica activa.
- Criterios de reperfusión a los 60–90 min: descenso del ST >50%, alivio del dolor, arritmias de reperfusión (RIVA); si falla → angioplastía de rescate. Siempre trasladar a centro con hemodinamia en 2–24 h.
- Complicación principal: hemorragia (intracraneal ~1%); estreptoquinasa produce hipotensión y alergia y no debe repetirse. No trombolizar el SCA sin supradesnivel.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 56 años en un hospital sin hemodinamia, con dolor torácico opresivo de 2 horas de evolución y supradesnivel del ST de 3 mm en V1–V4. El traslado a un centro con angioplastía tomaría unas 3 horas. Sin antecedentes de ACV ni sangrado. **¿Cuál es la conducta de reperfusión más adecuada?**

A Esperar troponinas antes de decidir

B Trasladar para angioplastía primaria sin otra medida

C Trombolisis solo si el dolor supera las 12 horas

D Solo aspirina y enoxaparina, sin reperfusión

E Trombolisis con tenecteplase y luego traslado a centro con hemodinamia

Respuesta E. En IAM con SDST de <12 horas, si la angioplastía no puede realizarse en <120 minutos, se indica trombolisis lo antes posible (meta <30 min) y traslado posterior a un centro con hemodinamia. No se esperan troponinas para reperfundir.

02
DIABETES Y NUTRICIÓN

68 CÓDIGOS

150 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	19
Situaciones clínicas de urgencia	7
Conocimientos generales	14
Exámenes e imagenología	25
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	3

Situaciones clínicas

19 códigos

▶ VER CLASE 1.02.1.001 Desnutrición

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.22 · Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en adulto mayor, alcohólico, enfermo crónico u hospitalizado: baja de peso involuntaria ≥4,5 kg o ≥5 % en un año, IMC bajo, sarcopenia y debilidad.
- Confirmar con evaluación nutricional: antropometría (IMC, circunferencia de pantorrilla), MNA (<17 desnutrición, 17–23,5 riesgo) y laboratorio (albúmina, prealbúmina, linfocitos).
- Buscar la causa: ingesta insuficiente (pobreza, depresión, demencia, dentadura), malabsorción, cáncer, ERC, hipertiroidismo, fármacos.
- Manejo inicial: aporte proteico 1,2–1,5 g/kg/día repartido en las comidas, suplementos orales, vitamina D si está baja y ejercicio de fuerza.
- En desnutrición severa realimentar de forma gradual (riesgo de síndrome de realimentación: hipofosfemia, hipokalemia) y dar tiamina antes de la glucosa.
- Seguimiento: derivar a nutricionista/equipo especializado; control de peso seriado.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 80 años, que vive solo, ha bajado 8 kg en 4 meses (de 64 a 56 kg). Come una vez al día, tiene la prótesis dental en mal estado y menor fuerza de prensión. Su IMC actual es 19 kg/m² y la albúmina es 3,1 g/dL. La evaluación inicial no muestra signos de cáncer. **¿Cuál es el diagnóstico nutricional más adecuado?**

A Estado nutricional normal, porque el IMC es mayor de 18,5

B Sobrepeso

C Obesidad sarcopénica

D Desnutrición proteico-calórica, por pérdida de peso significativa

E Caquexia neoplásica confirmada

Respuesta D. Una pérdida mayor al 5% en 3 meses o al 10% en 6 meses es significativa: él perdió 12,5% en 4 meses. En el adulto mayor un IMC bajo 23 ya se considera enflaquecido. Se suman baja ingesta, problemas dentales, aislamiento y menor fuerza: desnutrición, con manejo multidimensional y social.

▶ VER CLASE 1.02.1.002 Diabetes gestacional

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 1.3 · Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)
Diabetes 2.4 · Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizaje: glicemia de ayuno a toda embarazada al ingreso y PTGO 75 g universal a las 24–28 semanas (repetir a las 32–34 si hay feto grande, polihidramnios o DMG previa).
- Diagnóstico: dos glicemias de ayuno ≥100 mg/dL en días distintos, o PTGO con basal ≥100 o 2 h ≥140 mg/dL (basta un valor). En el embarazo no existe la prediabetes.
- Ayuno 100–125 al ingreso: repetir de inmediato (no pedir PTGO); si vuelve ≥100 es DMG. Si ≥126 antes de las 12 semanas: diabetes pregestacional.
- Tratamiento inicial: terapia nutricional fraccionada (4 comidas + 2–3 colaciones, nunca <1.500 kcal) con automonitoreo 4–6 veces/día por 1–2 semanas; metas: ayuno 70–90/95, 1 h <140, 2 h <120 mg/dL.
- Iniciar insulina (NPH nocturna si falla el ayuno, rápida precomida si falla el postprandial) si >20 % de valores fuera de meta o CA fetal ≥p75–90. Glibenclamida contraindicada.
- Riesgo: macrosomía, polihidramnios, distocia de hombros, hipoglicemia neonatal. Seguimiento: derivar a alto riesgo obstétrico; PTGO a las 6–12 semanas posparto.

PREGUNTAS · 9

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 44

Una paciente de 30 años, acude a su primer control de un embarazo de 10 semanas. Sus partos anteriores fueron eutócicos, con recién nacidos de término de 4 kilogramos. Entre sus exámenes de control trae un Elisa VIH que resultó negativo, hematocrito de 38%, glicemia de ayuno de 112 mg/dL y urocultivo negativo. Su examen físico es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral

B Iniciar metformina oral

C Repetir glicemia de ayuno

D Repetir el urocultivo

E Mantener el control embarazo normal

Respuesta C. Glicemia de ayuno ≥ 100 mg/dL en el embarazo: sospecha de diabetes gestacional, que se confirma repitiendo la glicemia de ayuno. La PTGO sería la conducta en una mujer no embarazada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 133

Una paciente de 36 años, cursando su primer embarazo a las 28 semanas, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, con 75 gramos de glucosa, que arroja una glicemia basal de 98 mg/dl y una glicemia postcarga, a las 2 horas, de 147 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Resistencia a la insulina

B Diabetes mellitus gestacional

C Diabetes mellitus pregestacional

D Intolerancia a la glucosa oral

E Embarazo normal

Respuesta B. PTGO a las 2 horas ≥ 140 mg/dL en una embarazada: diabetes gestacional. Basta un valor alterado aunque la basal sea normal. La intolerancia a la glucosa no existe en el embarazo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 81

Una paciente de 29 años, cursando un embarazo de 28 semanas, se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa oral, que muestra glicemia basal de 86 mg/dl y glicemia poscarga de 139 mg/dl. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Repetir la prueba de tolerancia a la glucosa a las 32 semanas

B Iniciar metformina

C Iniciar dieta hipoglucídica

D Iniciar insulina

E Mantener el control normal del embarazo

Respuesta E. Basal < 100 y postcarga < 140 mg/dL: PTGO normal. Sin factores de alto riesgo (feto grande, polihidramnios, DMG previa) no se repite a las 32–34 semanas: control normal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 133

Una mujer de 34 años, cursando un embarazo de 24 semanas, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, con 75 gramos de glucosa, que resulta 205 a las 2 horas. **Además de dieta y ejercicio, el tratamiento de elección es:**

A Acarbosa

B Sitaglipina

C Metformina

D Insulina

E Glibenclamida

Respuesta D. Diabetes gestacional: primero terapia nutricional y, si no se logran las metas, insulina, que es el fármaco de elección en el embarazo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Primigesta de 26 años, embarazo de 10 semanas, asintomática. En sus exámenes de ingreso tiene glicemia de ayuno de 108 mg/dL. Se repite a los 4 días en ayuno estricto: 106 mg/dL. Sin glucosuria ni antecedentes familiares de diabetes. **¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?**

A Glicemia de ayuno alterada

B Diabetes mellitus gestacional

C Diabetes mellitus pregestacional

D Embarazo normal; solicitar PTGO a las 24–28 semanas

E Intolerancia a la glucosa del embarazo

Respuesta B. En el embarazo no existe la glicemia de ayuno alterada. Dos glicemias de ayuno ≥ 100 mg/dL y < 126 mg/dL: diabetes gestacional. No es pregestacional porque para eso se necesitan valores de no embarazada (≥ 126 mg/dL). Se deriva a alto riesgo obstétrico y se inicia plan de alimentación.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Gestante de 27 semanas con diabetes gestacional diagnosticada hace 10 días, en plan de alimentación guiado por nutricionista. Registro de hemoglucotest: 7 de 20 controles postprandiales (35 %) sobre 155 mg/dL; glicemias de ayuno entre 82 y 88 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener la dieta y reevaluar en un mes

B Iniciar glibenclamida antes del almuerzo

C Iniciar insulina NPH nocturna a las 22:00

D Iniciar insulina rápida (cristalina o lispro) antes de las comidas

E Restringir la dieta a 1.200 kcal/día

Respuesta D. Más del 20 % de los controles fuera de meta tras 1 a 2 semanas de dieta: falla de la terapia nutricional. El ayuno está en meta; lo alto es el postprandial, así que se indica insulina rápida precomida. La NPH corrige el ayuno, la glibenclamida está contraindicada y bajar de 1.500 kcal produce cetosis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 166

paciente con diabetes gestacional 28 semanas, con tto metformina pero con cifras elevadas de glicemia, se preguntaba cómo continuar tto

A Pioglitazona
B agregar insulina
C Glibenclamida
D Sitagliptina
E Metformina

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Pioglitazona). agregar insulina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 108

Embarazada 24 semanas con glicemia post 75gr de glucosa en 200 ¿Cual es el manejo?

A Iniciar insulina
B Metformina
C Glibenclamida
D Interrupción del embarazo
E Maduración pulmonar y observación

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Iniciar insulina (opción A). Frente a descompensación metabólica aguda, cetoacidosis o hiperglicemia severa refractaria, la insulinoterapia endovenosa continua con monitorización seriada de electrolitos (especialmente potasio) es la piedra angular del manejo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 88

Una paciente de 22 años, acude a su primer control de un embarazo de 8 semanas. Entre sus exámenes trae un VDRL que resultó negativo, hematocrito de 39% y glicemia de ayuno de 112 mg/dL. Su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecua- da?

A Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
B Iniciar hipoglicemiantes orales
C Repetir glicemia de ayuno
D Solicitar insulinemia basal
E Mantener el control embarazo normal

Respuesta C. Tiene una glicemia de ayuno mayor o igual 100, lo que en el embarazo, obliga a re- petir la glicemia de ayuno.

▶ VER CLASE 1.02.1.003 Diabetes mellitus pregestacional

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 1.3 · Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)
Diabetes 2.4 · Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante

QUÉ HAY QUE SABER

- Diabetes previa al embarazo, o criterios de no embarazada antes de las 12 semanas (ayuno ≥126 mg/dL dos veces o glicemia ≥200 con síntomas).
- Riesgo propio: malformaciones por hiperglicemia en la organogénesis (cardíacas, regresión caudal), aborto, RCIU y muerte in utero, además de macrosomía.
- Planificación preconcepcional: HbA1c lo más cercana a la normalidad (<6,5 %) antes de embarazarse, ácido fólico, suspender IECA/ARA-II y estatinas, fondo de ojo y función renal.
- Tratamiento de elección: insulina (NPH + cristalina o análogos); metas estrictas ayuno 70–95 y 1 h postprandial <140 mg/dL, sin hipoglicemias. No usar sulfonilureas.
- Seguimiento: control conjunto con alto riesgo obstétrico; fondo de ojo por trimestre, función renal y albuminuria, ecografía morfológica y ecocardiografía fetal.
- Posparto: mantiene su tratamiento previo (la insulina baja rápido al salir la placenta); fomentar lactancia y anticoncepción planificada.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 176

Una mujer cursa un embarazo de 10 semanas y se realiza una glicemia de ayuno, que resulta 128 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Prediabetes
B Diabetes mellitus gestacional
C Glicemia de ayuno alterado
D Diabetes mellitus pregestacional
E Intolerancia a la glucosa oral

Respuesta D. Glicemia de ayuno ≥ 126 mg/dL antes de las 12 semanas: sospecha de diabetes pregestacional (se confirma con una segunda glicemia ≥ 126 mg/dL). Prediabetes, GAA e ITG no existen en el embarazo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 107

Una paciente embarazada de 10 semanas se realiza una glicemia de ayuno en su control del embarazo, que resulta 130 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Glicemia normal para el embarazo
B Intolerancia a la glucosa oral
C Diabetes mellitus gestacional
D Diabetes mellitus pregestacional
E Resistencia a la insulina

Respuesta D. Una glicemia de ayuno ≥ 126 mg/dL al inicio del embarazo hace sospechar una diabetes pregestacional, que se confirma con una segunda glicemia ≥ 126 mg/dL. Si los valores estuvieran entre 100 y 125 mg/dL sería diabetes gestacional.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 180

Una paciente embarazada de 9 semanas, se realiza una glicemia de ayuno en su control del embarazo, que resulta 130 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Glicemia normal para el embarazo
B Intolerancia a la glucosa
C Diabetes mellitus gestacional
D Diabetes mellitus pregestacional
E Prediabetes

Respuesta D. Es una mala pregunta, porque solo dan 1 glicemia, lo que no diagnostica nada. Sin embargo, se considera diabetes pregestacional que haya 2 glicemias de ayuno mayores o iguales a 126, a inicio del embarazo. Así mismo, se considera diabetes gestacional, si las dos glicemias son mayores o iguales a 100, pero menores a 126.

▶ VER CLASE 1.02.1.004 Diabetes Mellitus tipo 1

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 1.1 · Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY
Diabetes 3.1 · Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio
Diabetes 3.2 · Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Déficit absoluto de insulina por destrucción autoinmune de la célula beta (5–10 % de los diabéticos). Niño, adolescente o adulto joven normo o bajo peso.
- Debut agudo y catabólico: poliuria, polidipsia, polifagia y baja de peso marcada; 25–30 % debuta con cetoacidosis.
- Confirmar con criterios de diabetes; si hay duda, péptido C bajo o indetectable y anticuerpos positivos (anti-GAD65, anti-IA2, IAA, ZnT8). LADA: adulto con otra autoinmunidad y falla precoz a orales.
- Tratamiento inicial: insulina obligatoria (no responde a orales); esquema basal-bolo desde el inicio. Descartar y tratar cetoacidosis si hay vómitos, dolor abdominal o Kussmaul.
- Es patología GES: derivar a endocrinología/diabetología para educación, insulinoterapia intensificada y automonitoreo.
- Tamizaje de complicaciones desde el 5.º año del debut: RAC, fondo de ojo y examen de pies anual; buscar otras autoinmunidades (tiroides, celiaquía).

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 113

Una paciente de 36 años, hipotiroidea y con antecedente de vitíligo fue diagnosticada de diabetes hace un año. Está en tratamiento con 2 gramos de metforminal al día y 20 mg de glibenclamida al día, más dieta. Su hemoglobina glicosilada es de 8,5% y su glicemia de ayuno resulta 196 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Diabetes mellitus 1 - LADA
B Diabetes mellitus Mody
C Diabetes mellitus secundaria
D Diabetes mellitus 2 con tendencia a la cetosis
E Diabetes mellitus controlada

Respuesta A. Autoinmunidad asociada (hipotiroidismo y vitíligo) más mal control pese a dosis altas de metformina y glibenclamida: diabetes LADA, la autoinmune del adulto, que se trata con insulina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 17

Un paciente de 12 años, diabético tipo 1, en tratamiento con una dosis de NPH matinal, despierta con glicemias de ayuno muy elevadas, asociadas a hipoglicemias frecuentes antes del almuerzo. Su hemoglobina glicosilada es de 11,7%. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Reemplazar el tratamiento por insulina glargina en la mañana
B Dejar dos dosis de insulina NPH más tres refuerzos de insulina cristalina precomidas
C Agregar insulina NPH nocturna
D Reemplazar la insulina NPH matinal por insulina NPH nocturna
E Agregar metformina al tratamiento

Respuesta B. La DM1 se trata con esquema intensificado basal-bolo. Una sola NPH matinal hace su peak antes del almuerzo (hipoglicemia) y se agota en la noche (ayuno alto). Dos NPH más tres bolos de cristalina es un basal-bolo aceptable.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 28 años con tiroiditis de Hashimoto en tratamiento con levotiroxina, IMC 21,5 kg/m². Consulta por polidipsia, astenia y baja de 4 kg en 2 meses. Glicemia de ayuno 285 mg/dL, HbA1c 10,2 %, sin cetonuria. Se inició metformina, sin descenso glicémico tras 4 semanas de escalamiento. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Agregar glibenclamida y controlar en 3 meses

B Solicitar anti-GAD65 y péptido C, e iniciar insulina

C Solicitar estudio genético para MODY

D Solicitar una prueba de tolerancia a la glucosa oral

E Aumentar la metformina a dosis máxima

Respuesta B. Adulta joven, delgada, con autoinmunidad previa (Hashimoto), hiperglicemia sintomática y falla a metformina: LADA. Se piden anti-GAD65 y péptido C y se inicia insulina de inmediato para frenar el catabolismo. Sumar orales solo retrasa el tratamiento.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Joven de 20 años con DM1, en tratamiento con una dosis matinal de NPH y cristalina antes de desayuno, almuerzo y cena. Registro de 7 días: ayunas 105, post-desayuno 120, pre-almuerzo 110, post-almuerzo 238, pre-cena 125 y post-cena 130 mg/dL. Asintomático, cumple su dieta. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Aumentar la dosis de NPH matinal

B Aumentar la cristalina previa al almuerzo

C Agregar una dosis de NPH antes del almuerzo

D Aumentar la cristalina previa al desayuno

E Indicar una colación proteica a media tarde

Respuesta B. Todo el registro está en meta (80–130 preprandial, < 180 postprandial) salvo el post-almuerzo. La insulina que actúa sobre esa glicemia es la cristalina previa al almuerzo: se aumenta esa dosis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 34

Una paciente de 40 años, con antecedente de hipotiroidismo desde la adolescencia, vitíligo y diabetes diagnosticada hace un año, en tratamiento con régimen oral, acude a control con glicemia de ayuno en 250 mg/dL y hemoglobina glicosilada en 9,0%. El diagnóstico más probable es:

A Diabetes mellitus tipo 1

B Diabetes mellitus tipo 2

C Diabetes mellitus autoinmune

D Hipopituitarismo autoinmune

E Neoplasia endocrina múltiple tipo 1

Respuesta C. El diagnóstico es una diabetes LADA, que si bien es igual a la DM1, tiene un nombre distinto. Orientan el vitíligo, el hipotiroidismo (autoinmunes ambos) y la falta de respuesta.

▶ VER CLASE 1.02.1.005 Diabetes mellitus tipo 2

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 1.1 · Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY
Diabetes 1.2 · Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS
Diabetes 1.4 · Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas
Diabetes 2.1 · Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL
Diabetes 2.2 · Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas
Diabetes 2.3 · Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4
Diabetes 3.1 · Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio
Diabetes 3.2 · Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis
Diabetes 3.3 · Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico: glicemia de ayuno ≥126 mg/dL (2 veces), PTGO 2 h ≥200, HbA1c ≥6,5 % (confirmar en asintomático) o glicemia al azar ≥200 con síntomas (no se repite). Ayuno 100–125: PTGO.
- GES en ≥15 años: confirmación en 45 días y tratamiento en 24 horas. Desde el inicio: estilo de vida (baja de 5–10 % del peso, 150 min/semana de ejercicio) + metformina 500–850 mg titulando hasta 1.700–2.550 mg/día.
- Meta HbA1c <7 % (joven sin riesgo <6,5 %; adulto mayor activo <7,5 %; frágil <8–8,5 %). Control a los 3 meses: si está sobre la meta con dosis plena, agregar 2.º fármaco (glibenclamida en APS; iSGLT2 si IC o ERC; GLP-1 si enfermedad aterosclerótica).
- Insulina NPH nocturna 10 UI o 0,1–0,2 UI/kg + metformina si HbA1c ≥9–10 %, glicemia >250–300, catabolismo, cetonuria o falla de biterapia; titular +2 UI (ayuno 131–180) o +4 UI (>180) cada 3–7 días.
- Metformina: ajustar a VFG (30–44: máx. 1.000 mg; <30: suspender). Glibenclamida: evitar en adulto mayor y nefrópata por hipoglicemia prolongada.
- Seguimiento completo en APS (PSCV): HbA1c cada 3–6 meses, PA <130/80, LDL <70, RAC y fondo de ojo anual desde el diagnóstico, monofilamento anual.

PREGUNTAS · 21

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 114

Un paciente de 32 años, normopeso, diagnosticado de diabetes desde los 20 años, en tratamiento. Su padre, su hermano y su abuelo son diabéticos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A DM tipo 1
B DM tipo 2
C DM LADA
D DM Mody
E DM mitocondrial

Respuesta D. Diabetes diagnosticada antes de los 25 años en un paciente normopeso, con tres generaciones afectadas (abuelo, padre, hermano): herencia autosómica dominante, típica de la MODY. La LADA es autoinmune y no se repite así en la familia; la mitocondrial se hereda por vía materna.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 33

Un paciente de 17 años, obeso, se realiza chequeo con glicemia de ayuno que resulta en 130, por lo que se repite este examen obteniendo 137, no ha presentado síntomas. En el examen físico destaca presencia de acantosis nígricans en pliegue cervical y acrocordones. **El diagnóstico más probable es:**

A Diabetes mellitus tipo 1
B Diabetes mellitus tipo 2
C Diabetes mellitus autoinmune
D Intolerancia a la glucosa
E Glicemia de ayuno alterada

Respuesta B. Dos glicemias de ayuno ≥ 126 mg/dL confirman diabetes. En un adolescente obeso, asintomático y con acantosis nigricans y acrocordones (resistencia a la insulina), el tipo más probable es la DM2, pese a la edad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 24

Un paciente de 81 años, con antecedente de diabetes, en tratamiento con metformina 850 al día, se realiza exámenes de control, entre los que destaca una hemoglobina A1c de 7,5%. **La conducta más adecuada es:**

A Mantener el tratamiento
B Agregar glibenclamida
C Subir la dosis de metformina
D Agregar insulina
E Agregar sitagliptina

Respuesta A. En el adulto mayor la meta de HbA1c se flexibiliza (bajo 7,5–8 %). Con 7,5 % está en meta: se mantiene el tratamiento.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 105

Un paciente de 59 años, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con metformina 850mg dos veces al día y glibenclamida 5mg cada 12 horas, se realiza exámenes de control entre los que destaca una creatinina de 1,0 mg/dL y una hemoglobina glicosilada de 6,9%. Su examen físico no muestra alteraciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Suspender la glibenclamida
B Aumentar dosis de glibenclamida
C Suspender metformina
D Aumentar dosis de metformina
E Mantener el tratamiento sin cambios

Respuesta E. Adulto de 59 años con HbA1c bajo 7 %, función renal normal y sin hipoglicemias: está en meta, no se modifica el tratamiento.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 118

Un paciente de 85 años, con antecedente de deterioro funcional y cognitivo inicial y diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con metformina 850 mg dos veces al día y glibenclamida 5 mg cada 12 horas, se realiza exámenes de control entre los que destaca una creatinina de 1,0 mg/dL y una hemoglobina glicosilada de 6,9%. Su examen físico no muestra alteraciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Suspender la glibenclamida
B Disminuir la dosis de glibenclamida a 5 mg una vez al día
C Suspender metformina
D Disminuir dosis de metformina
E Mantener el tratamiento sin cambios

Respuesta A. Adulto mayor frágil (85 años, deterioro funcional y cognitivo): meta de HbA1c bajo 8–8,5 %. Con 6,9 % está sobretratado y en riesgo de hipoglicemia; se suspende la glibenclamida, la sulfonilurea que la produce, y se mantiene la metformina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 132

Un paciente de 45 años se realiza glicemias de ayuno que resultan 128 y 136 mg/dl. Se solicita hemoglobina glicosilada, que resulta 7,2%. **¿Cuál es el tratamiento de elección para iniciar el manejo de este paciente?**

A Glibenclamida
B Metformina
C Pioglitazona
D Sitagliptina
E Repaglinida

Respuesta B. Tiene diagnóstico de diabetes (dos glicemias de ayuno ≥ 126 mg/dL). Por la edad y la ausencia de otros antecedentes, lo más probable es que sea tipo 2. Sin indicaciones de insulina, se inicia metformina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 17

Un hombre de 33 años, obeso, consulta por polidipsia y baja de peso de 6 kilogramos, en los últimos dos meses. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicitan exámenes, entre los que destacan glicemia de ayuno de 245 mg/dl y hemoglobina glicosilada: 9,2%. **El tratamiento inicial más adecuado es:**

A Metformina
B Sitagliptina
C Insulina
D Liraglutide
E Glibenclamida

Respuesta C. Tanto por los síntomas de diabetes (baja de peso y polidipsia) como por la HbA1c mayor a 9%, está indicada la insulina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 151

Diabético en tratamiento con metformina, Hb1Ac >9%. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Agregar glibenclamida 5 mg/día
B Agregar sitagliptina 100 mg/día
C Agregar liraglutida 1,2 mg SC
D Aumentar metformina al máximo
E Insulina NPH

Respuesta E. Con metformina y HbA1c sobre 9%, ningún segundo fármaco oral o GLP-1 alcanza a bajarla a la meta: está indicada la insulina NPH, manteniendo la metformina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 125

Un paciente de 55 años, diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina 2000mg al día, glibenclamida 15mg al día y enalapril 20mg al día, acude a control con exámenes, donde destaca glicemia de ayuno de 180mg/dL y hemoglobina glicosilada de 8,8%. Se ha mantenido sin síntomas y su examen físico es normal. **La conducta más adecuada en este caso es:**

A Aumentar dosis de glibenclamida
B Aumentar dosis de metformina
C Iniciar insulina
D Reemplazar metformina con rosiglitazona
E Reemplazar glibenclamida con sitagliptina

Respuesta C. Ya está en biterapia con dosis altas de metformina y glibenclamida. Subir un poco más los orales tendría poco efecto para una HbA1c de 8,8%: la falla de la biterapia oral indica iniciar insulina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 141

Un paciente con antecedente de una angioplastia coronaria hace 6 meses, diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina 2 gramos al día, presenta HbA1c de 8,2% y glicemia de ayuno de 180 mg/dl. **¿Cuál es el tratamiento más adecuada?**

A Agregar glibenclamida
B Iniciar empaglifozina
C Iniciar saxagliptina
D Agregar insulina NPH nocturna
E Iniciar pioglitazona

Respuesta B. Con enfermedad coronaria establecida, los fármacos de elección para agregar a la metformina son los que reducen eventos cardiovasculares: iSGLT2 como la empagliflozina, o agonistas GLP-1.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 107

Un paciente de 72 años, con antecedente de un infarto miocárdico, hace 2 meses. Durante la hospitalización, se diagnosticó diabetes mellitus, iniciándose metformina 850 mg cada 12 horas. Sin embargo, desde entonces ha presentado diarrea. Sus glicemias de ayuno son cercanas a 140 mg/dl y su hemoglobina glicosilada resulta 8,2%. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Reemplazar la metformina por glibenclamida

B Agregar insulina NPH

C Reemplazar el tratamiento por metformina 750 mg XR

D Reemplazar la metformina por sitagliptina

E Aumentar la dosis de metformina

Respuesta D. La metformina le produce efectos adversos, por lo que se suspende. En un adulto mayor con infarto reciente, se prefiere la sitagliptina sobre la glibenclamida por su seguridad (sin hipoglicemia). No tiene indicaciones de insulina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 149

Un paciente de 82 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina y dieta, acude a control, con glicemia de ayuno de 355 mg/dl, hemoglobina glicosilada de 9,5%. **¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de su diabetes?**

A Agregar glibenclamida

B Agregar sitagliptina

C Inicial insulina NPH

D Iniciar insulina glargina

E Iniciar liraglutide

Respuesta C. Glicemia de ayuno > 300 mg/dL y HbA1c > 9 %: indicación de insulina. La insulina basal de inicio en atención primaria es la NPH al acostarse, manteniendo la metformina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 161

Paciente de 65 años con DM2 en tratamiento con insulina NPH nocturna. Presenta hiperglicemias en ayuno de 200-240 mg/dL. Glicemias a las 3 AM: 65 mg/dL. **¿Cuál es el ajuste más adecuado?**

A Agregar glibenclamida

B Agregar sitagliptina

C Agregar pioglitazona

D Reducir dosis de insulina NPH nocturna

E Cambiar a insulina basada en metformina

Respuesta D. Efecto Somogyi: hipoglicemia a las 3 AM seguida de hiperglicemia de rebote en ayuno. La solución es REDUCIR la NPH nocturna, no aumentarla.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 49 años, transportista, IMC 31 kg/m², hipertenso, asintomático. En un examen preventivo laboral presenta glicemia de ayuno de 132 mg/dL. Niega polidipsia y baja de peso. Consulta en su CESFAM. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Confirmar diabetes mellitus tipo 2 e iniciar metformina

B Repetir la glicemia de ayuno en otro día

C Solicitar una PTGO con 75 g

D Solicitar péptido C y anticuerpos anti-GAD

E Control con glicemia de ayuno en 3 años

Respuesta B. Asintomático con una única glicemia de ayuno ≥ 126 mg/dL: no basta para diagnosticar. Se repite la glicemia de ayuno en un día distinto; si vuelve a ser ≥ 126 mg/dL se confirma DM2 y se ingresa a GES. La PTGO corresponde a una glicemia de 100–125 o a un resultado discordante.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 82 años, DM2 de 20 años de evolución, artrosis severa y ERC etapa 3b (VFG 38 mL/min). Usa insulina NPH nocturna 14 UI y metformina 500 mg/día. HbA1c 7,7 %, glicemias preprandiales matinales de 115 a 135 mg/dL, sin hipoglicemias. Pregunta si debe aumentar la insulina. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Aumentar la NPH hasta lograr HbA1c < 7 %

B Agregar glibenclamida 5 mg en la mañana

C Mantener el esquema actual

D Agregar insulina cristalina antes de cada comida

E Suspender la insulina y dejar solo metformina

Respuesta C. Adulto mayor de 82 años, con ERC y movilidad reducida: la meta de HbA1c es 7,5–8,5 %. Con 7,7 % y sin hipoglicemias está en meta; intensificar solo aumenta el riesgo de hipoglicemia nocturna, caídas y eventos cardiovasculares.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 57 años con DM2 diagnosticada hace 4 meses. Inició cambios de estilo de vida y metformina 850 mg cada 12 horas. Acude a control con HbA1c de 8,3%. No presenta baja de peso ni poliuria, ni antecedentes cardiovasculares. Creatinina 0,9 mg/dL. **¿Cuál es la conducta indicada según la guía GES?**

A Suspender metformina e iniciar insulina NPH nocturna

B Mantener metformina y asociar glibenclamida

C Reforzar la dieta y controlar en 3 meses

D Reemplazar metformina por glibenclamida

E Hospitalizar para insulina endovenosa

Respuesta B. Falla de la monoterapia con metformina a dosis terapéutica tras 3 meses (HbA1c 8,3%, meta < 7%). Está asintomático, sin catabolismo ni cetonuria: no tiene criterios de insulina. Se mantiene la metformina y se agrega un segundo oral; en la canasta GES de APS, glibenclamida 2,5 a 5 mg/día.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 56 años con DM2 de 8 años, con metformina 850 mg c/8 h y glibenclamida 10 mg c/12 h, adherencia confirmada. Consulta por astenia, baja de 5 kg en 2 meses y nicturia. IMC 27, PA 130/80. Glicemia de ayuno 264 mg/dL, HbA1c 10,4 %, creatinina 0,9 mg/dL, orina sin cetonas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Agregar sitagliptina y controlar en 3 meses

B Iniciar NPH al acostarse, manteniendo la metformina

C Aumentar la glibenclamida a dosis máxima

D Suspender los orales e iniciar insulina cristalina endovenosa

E Iniciar NPH con la cena y suspender la metformina

Respuesta B. Falla secundaria a biterapia oral a dosis plenas, con HbA1c > 10 % y síntomas catabólicos: se inicia insulina basal, NPH al acostarse (10 UI o 0,1–0,2 UI/kg), manteniendo la metformina. La NPH con la cena produce hipoglicemia nocturna; la vía endovenosa es para el paciente hospitalizado grave.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 64 años, DM2 en tratamiento con glibenclamida 5 mg cada 12 horas. Cursa el segundo día postoperatorio de una colecistectomía, hemodinámicamente estable y tolerando régimen oral completo. Ha tenido glicemias capilares entre 220 y 260 mg/dL. Pesa 80 kg y su función renal es normal. **¿Cuál es el manejo más adecuado de su diabetes durante la hospitalización?**

A Reiniciar glibenclamida a la misma dosis

B Insulina cristalina según hemoglucotest cada 6 horas como única terapia

C Insulina basal más bolos prandiales de insulina rápida y escala de corrección

D Infusión endovenosa continua de insulina cristalina

E Observar sin tratamiento hasta que la glicemia supere 300 mg/dL

Respuesta C. Paciente no crítico que tolera alimentación: esquema basal-bolo-corrección subcutáneo, con meta de 140–180 mg/dL. La glibenclamida se suspende al ingreso por riesgo de hipoglicemia prolongada; el esquema móvil aislado está proscrito; la infusión EV se reserva para el paciente crítico.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 72 años, diabético tipo 2 en tratamiento ambulatorio regular con metformina 850 mg cada 8 horas, ingresa al hospital por un cuadro de sepsis de foco urinario, evidenciándose PA 88/55 mmHg, taquicardia de 112 lpm y creatinina plasmática de 2.2 mg/dL. Su glicemia capilar de ingreso es de 260 mg/dL. **¿Cuál es la indicación farmacológica más apropiada para el manejo de su diabetes durante la hospitalización?**

A Continuar metformina y agregar glibenclamida 5 mg cada 12 horas

B Suspender metformina e indicar insulina cristalina en esquema móvil aislado según hemoglucotest cada 6 horas

C Suspender metformina e iniciar insulinoterapia con esquema basal más correcciones de insulina rápida subcutánea

D Mantener metformina reduciendo la dosis a la mitad y administrar bicarbonato profiláctico

E Indicar hidratación vigorosa sin administrar hipoglucemiantes hasta que la glicemia supere los 300 mg/dL

Respuesta C. Sepsis con hipotensión y falla renal aguda: la metformina se suspende de inmediato por riesgo de acidosis láctica. El esquema móvil aislado está proscrito. Lo correcto es insulina programada: basal más correcciones de insulina rápida subcutánea, con meta de 140–180 mg/dL.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 162

Un paciente de 45 años, presenta polidipsia y poliuria de 4 semanas de evolución, asociado a baja de peso de 4 kilogramos en un mes. Al examen físico, se observa obeso con IMC: 35 y con presencia de acantosis nigricans en el cuello, sin otras alteraciones. Se solicita glicemia de ayuno, que resulta 318 mg/dl.

A Iniciar dieta y metformina

B Iniciar dieta y controlar

C Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral

D Repetir la glicemia de ayuno

E Iniciar insulina

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Iniciar dieta y metformina). El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 se basa en un enfoque escalonado que comienza siempre con cambios en el estilo de vida (dieta y ejercicio) más metformina como fármaco de primera línea.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 150

Paciente con polidipsia, poliuria, baja de peso y glicemia >300 mg/dL. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

A Metformina 850 mg cada 12 horas
B Iniciar insulina
C Empagliflozina 10 mg/día
D Liraglutida 0,6 mg subcutáneo
E Sitagliptina 100 mg/día

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Iniciar insulina (opción B). Iniciar insulina. Frente a descompensación metabólica aguda, cetoacidosis o hiperglicemia severa refractaria, la insulinoterapia endovenosa continua con monitorización seriada de electrolitos (especialmente potasio) es la piedra angular del manejo.

▶ VER CLASE 1.02.1.006 Diabetes por corticoides

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 3.3 · Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado

QUÉ HAY QUE SABER

- Hiperglicemia inducida por glucocorticoides (también tacrolimus, antipsicóticos atípicos); predomina la hiperglicemia vespertina/postprandial con ayuno casi normal.
- Sospechar en paciente con corticoides sistémicos y glicemias >140 mg/dL; en el hospitalizado la HbA1c ≥6,5 % indica que ya era diabético.
- Monitorizar con glicemia capilar antes de almuerzo y cena, no solo en ayunas.
- Tratamiento inicial: insulina programada (NPH matinal junto con la prednisona, ajustada a la dosis del corticoide) más corrección; nunca esquema móvil aislado. Meta hospitalaria 140–180 mg/dL.
- Al reducir el corticoide, bajar la insulina en la misma proporción para evitar hipoglicemias.
- Seguimiento: derivar si persiste hiperglicemia tras suspender el corticoide; reevaluar con HbA1c o glicemia de ayuno.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 93

Un paciente de 35 años, con antecedente de obesidad y resistencia a la insulina, presenta una reacción alérgica severa relacionada con el uso de fármacos, por lo que es hospitalizado para manejo con soporte y corticoides sistémicos. Durante su hospitalización se realizan exámenes entre los que destaca glicemia de 180 mg/dL, que se mantiene en rangos similares en varias tomas. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?**

A Péptido C
B Test de tolerancia a la glucosa oral
C Hemoglobina glicosilada
D Índice de HOMA
E Insulinemia postcarga de glucosa

Respuesta C. Con un descompensante agudo (reacción alérgica grave, corticoides) la glicemia y la PTGO salen alteradas por el estrés. La HbA1c refleja los 2–3 meses previos y es el examen de elección: ≥ 6,5 % confirma diabetes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 24

Mujer de 55 años con DM2 en tratamiento con metformina, requiere corticoterapia con prednisona 40 mg/día por enfermedad pulmonar. Sus glicemias de ayuno eran 130 mg/dL y post-prandiales suben a 280 mg/dL. **¿Cuál es el ajuste más adecuado?**

A Iniciar insulina
B Agregar metformina adicional
C Pioglitazona
D Glibenclamida
E Sitagliptina

Respuesta A. Los corticoides en dosis altas son una de las indicaciones de insulinoterapia: permiten ajustar rápido y con flexibilidad. Los hipoglicemiantes orales no logran el control necesario.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 169

Paciente hospitalizada con hidrocortisona endovenosa y glicemias elevadas persistentes. **¿Cuál es el examen para el diagnóstico?**

A Glicemia en ayunas
B Test de tolerancia oral a la glucosa
C Insulinemia basal
D Hemoglobina glicosilada (HbA1c)
E Péptido C

Respuesta D. La hiperglicemia hospitalaria se define con o sin diabetes previa. Con corticoides y estrés agudo, la glicemia no sirve para diagnosticar diabetes de base; la HbA1c refleja los últimos 2 a 3 meses y, si es ≥ 6,5%, certifica que la paciente ya era diabética antes del ingreso.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 24

Mujer de 55 años con DM2 en tratamiento con metformina requiere corticoterapia con prednisona 40 mg/día por una enfermedad pulmonar. Sus glicemias de ayuno son de 130 mg/dL y las postprandiales suben a 280 mg/dL. **¿Cuál es el ajuste más adecuado?**

A Iniciar insulina
B Agregar metformina adicional
C Pioglitazona
D Glibenclamida
E Sitagliptina

Respuesta A. Los corticoides producen hiperglicemia de predominio postprandial y vespertino por resistencia a la insulina. Con prednisona en dosis altas y glicemias de 280 mg/dL, la insulina (típicamente NPH matinal ajustada a la dosis del corticoide) es de elección por rapidez y flexibilidad. Los orales no logran control suficiente y la glibenclamida arriesga hipoglicemia nocturna.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 106

Asmática con crisis tratada con corticoides VO por 5 días, al 5to día se le solicita seguimiento con exámenes, presenta glicemia 130. Cuál es la conducta más apropiada

A Repetir glicemia en 1 semana
B Pedir hemoglobina glicosilada
C Solicitar PTGO
D Hemograma y VHS
E Ecografía

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Pedir hemoglobina glicosilada (opción B).

▶ VER CLASE 1.02.1.007 **Dislipidemias**

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 5.4 · Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas
Diabetes 5.5 · Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Primero estimar el riesgo cardiovascular, luego fijar la meta de c-LDL: muy alto (evento ateroesclerótico, DM con daño de órgano, VFG <45) <55–70 mg/dL; alto <70; moderado <100; bajo: estilo de vida.
- Calcular LDL con Friedewald (CT − HDL − TG/5) si TG <400. La meta es el LDL, no el colesterol total.
- Estatina según intensidad: alta (atorvastatina 40–80, rosuvastatina 20–40 mg; baja LDL ≥50 %) en riesgo muy alto y post SCA; moderada (atorvastatina 10–20, rosuvastatina 5–10). Sin meta con dosis máxima: + ezetimiba 10 mg.
- Mialgias con estatina: medir CK; normal = mialgia simple; 3–10 veces = miositis, suspender; >10 veces = rabdomiólisis.
- TG ≥500 mg/dL: prioridad prevenir pancreatitis con fenofibrato, cero alcohol y dieta pobre en grasas. Nunca gemfibrozilo con estatina.
- Hipercolesterolemia familiar: LDL ≥190 con TG normales, xantomas tendinosos, IAM familiar precoz; estatina máxima + ezetimiba. Seguimiento: perfil lipídico y transaminasas en PSCV.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 89

Paciente de 62 años, diabético diagnosticado hace 3 meses, en tratamiento con hipoglicemiantes orales, como parte de un chequeo se realiza exámenes de chequeo donde se aprecia creatinina de 0,9 mg/dL, hemoglobina glicosilada menor a 7% y un perfil lipídico que muestra triglicéridos: 250 mg/dL, colesterol total: 253 mg/dL, HDL: 51 mg/dL, LDL: 152 mg/dL. No presenta síntomas. **El tratamiento más adecuado para disminuir su riesgo cardiovascular es:**

A Fibratos
B Estatinas
C Dieta baja en ácidos grasos saturados
D Ácido nicotínico
E Ezetimibe

Respuesta B. Diabético de corta evolución: al menos riesgo moderado, con meta de c-LDL menor de 100 mg/dL. Un LDL de 152 está fuera de meta y los triglicéridos están bajo 500: la prioridad es el LDL y se indican estatinas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 41

Un paciente dislipidémico, está en tratamiento con atorvastatina 10 mg/día y se realiza un perfil lipídico de control con colesterol total: 183 mg/dl, colesterol HDL: 32 triglicéridos: 860 mg/dl. **¿Cuál es la dosis más adecuada?**

A Subir la dosis de la atorvastatina a 40 mg/día

B Cambiar la atorvastatina por rosivastatina

C Agregar gemfobrozilo 900 mg/día

D Agregar ezetimibe al tratamiento

E Reemplazar la atorvastatina por gemfibrozilo 900 mg/día

Respuesta E. Con triglicéridos sobre 500 mg/dL la prioridad es prevenir la pancreatitis con un fibrato. El gemfibrozilo no se combina con estatinas por el riesgo de rabdomiólisis, por eso se reemplaza la estatina en vez de agregarlo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 152

Diabético con HbA1c en buen rango, LDL 135 mg/dL y TG 330 mg/dL. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A Fenofibrato

B Gemfibrozilo

C Atorvastatina

D Omega-3 en dosis farmacológica

E Ezetimibe

Respuesta C. Triglicéridos bajo 500 mg/dL: la prioridad es el LDL. En un diabético con LDL de 135 (meta bajo 100 o menos), el tratamiento inicial es una estatina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 134

Un paciente de 35 años, en tratamiento con atorvastatina, por hipercolesterolemia y cuyo padre tuvo un infarto a los 40 años, presentó mialgias y artralgias, por lo que decidió suspender el medicamento, sin indicación médica. Se controla con exámenes, entre los que destaca colesterol total: 354 mg/dl, colesterol LDL: 244 mg/dl, colesterol HDL: 70 mg/dl, triglicéridos: 198 mg/dl, creatinfosfoquinasa: 254 UI/L. **El tratamiento más adecuado es:**

A Colestiramina

B Dieta estricta

C Rosuvastatina

D Ezetimibe

E Fenofibrato

Respuesta C. LDL de 244 con padre infartado a los 40 años: perfil de hipercolesterolemia familiar, que necesita estatina. Con mialgias y CK prácticamente normal, se cambia a otra estatina como rosuvastatina en vez de abandonar el tratamiento. Los demás fármacos no bastan para un LDL tan alto.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 70 años, con IAM hace 1 año, en tratamiento con atorvastatina 80 mg. Consulta por 3 días de dolor muscular intenso en muslos y hombros, debilidad y orinas oscuras. CK 15.000 UI/L, creatinina 2,1 mg/dL (basal 1,0). **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Mialgia simple por estatinas

B Miositis por estatinas

C Rabdomiólisis por estatinas

D Polimialgia reumática

E Polineuropatía diabética

Respuesta C. Dolor muscular intenso, orinas oscuras (mioglobinuria), CK mayor a 10 veces el límite normal e insuficiencia renal aguda: rabdomiólisis por estatinas. La mialgia simple tiene CK normal; la miositis, CK de 3 a 10 veces el límite normal sin falla renal.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 34 años consulta por nódulos indoloros y firmes en la cara posterior de ambos tobillos, sobre los tendones de Aquiles. Su padre falleció de un IAM a los 41 años. Perfil lipídico: colesterol total 340 mg/dL, HDL 48 mg/dL, triglicéridos 130 mg/dL, LDL 266 mg/dL. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hipercolesterolemia familiar heterocigota

B Hipertrigliceridemia familiar aislada

C Disbetalipoproteinemia familiar tipo III

D Hiperlipidemia familiar combinada

E Xantomatosis cerebrotendinosa recesiva

Respuesta A. LDL muy elevado (más de 190 mg/dL) con triglicéridos normales, xantomas tendinosos en el Aquiles (patognomónicos) y un familiar de primer grado con enfermedad coronaria precoz: hipercolesterolemia familiar heterocigota, autosómica dominante, por mutación del receptor de LDL.

▶ VER CLASE `1.02.1.008` **Hipertensión arterial en diabetes tipo 2** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 2.5 · Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- Meta PA <130/80 mmHg en el diabético (de forma gradual, sin hipotensión ortostática en ancianos); tratar aunque esté bajo 140/90.
- Con albuminuria (RAC ≥30 mg/g): IECA o ARA-II obligatorio (enalapril o losartán), que dilatan la arteriola eferente y reducen la proteinuria.
- Sin albuminuria: cualquier primera línea (IECA, ARA-II, amlodipino o tiazida). Betabloqueador solo si hay IAM previo o insuficiencia cardíaca.
- PA ≥140/90 al inicio: biterapia de entrada, IECA/ARA-II + amlodipino 5–10 mg o + tiazida.
- Nunca IECA + ARA-II (ONTARGET: más falla renal aguda e hiperkalemia). Controlar creatinina y potasio a las 1–2 semanas de iniciar.
- Seguimiento completo en PSCV: PA en cada control, RAC y VFG anual; con VFG <30 usar furosemida en vez de tiazida.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 56 años con DM2 en tratamiento con metformina 850 mg c/12 h, HbA1c 7,1 %. En sus últimos 3 controles presenta PA promedio de 144/92 mmHg. RAC 160 mg/g (confirmada) y creatinina 1,0 mg/dL. **¿Cuál es el antihipertensivo de primera línea?**

A Atenolol
B Hidroclorotiazida
C Enalapril o losartán
D Enalapril más losartán
E Furosemida

Respuesta C. Diabético hipertenso con albuminuria (RAC 30–299 mg/g): IECA o ARA-II, que dilatan la arteriola eferente, bajan la presión intraglomerular y reducen la proteinuria. Meta < 130/80. Con PA ≥ 140/90 se asocia amlodipino. Nunca IECA + ARA-II.

▶ VER CLASE 1.02.1.009 **Insuficiencia renal y diabetes** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.1 · Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector

QUÉ HAY QUE SABER

- Nefropatía diabética: primera causa de hemodiálisis; progresa de hiperfiltración a albuminuria y glomeruloesclerosis (Kimmelstiel-Wilson).
- Diagnóstico de ERC: VFG <60 mL/min/1,73 m² (CKD-EPI) y/o RAC ≥30 mg/g por más de 3 meses; etapificar por G (filtración) y A (albuminuria).
- Ajustar fármacos: metformina máx. 1.000 mg con VFG 30–44 y suspender <30; glibenclamida contraindicada <30; linagliptina sin ajuste renal; insulina con dosis menores (más riesgo de hipoglicemia).
- Nefroprotección: IECA o ARA-II (nunca juntos) + iSGLT2 si VFG >20–25; PA <130/80, HbA1c individualizada, evitar AINE y contraste.
- Vigilar hiperkalemia, anemia, acidosis y alteraciones del fósforo/PTH.
- Seguimiento: derivar a nefrología si VFG <30, RAC ≥300 mg/g, caída rápida de VFG o hiperkalemia persistente.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 37

Una paciente de 67 años, monorrena, es diagnosticada recientemente de diabetes mellitus tipo 2. Sus exámenes muestran HbA1c de 8,5%, glicemia de ayuno de 132 mg/dL, creatinina de 4,1 mg/dL, nitrógeno ureico de 68 mg/dL, potasio plasmático de 4,2 mEq/L y un clearance de creatinina estimado de 12 mL/min. Presenta una relación albuminuria/creatinuria de 1.100 mg/g. **¿Qué fármaco es el más adecuado para iniciar el tratamiento?**

A Metformina
B Glibenclamida
C Vildagliptina
D Dapagliflozina
E Semaglutida

Respuesta E. Con clearance de 12 mL/min, la metformina y la glibenclamida están contraindicadas; los iSGLT2 necesitan filtración para actuar (glucosuria) y no se inician con esta función renal; la vildagliptina se elimina por el riñón. Los agonistas GLP-1 como la semaglutida son la alternativa a la insulina, con beneficio cardiovascular.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 122

Un paciente de 78 años, diabético tipo 2 e hipertenso, sin controles hace 5 años, en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida, amlodipino y metformina, Acude a control, con exámenes de laboratorio. Su presión arterial es de 152/96 mmHg y su frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto. Su examen cardiopulmonar y abdominal es normal. Entre sus exámenes destaca hemoglobina glicosilada: 6%, creatinina plasmática: 3,8 mg/dL, natremia: 140 mEq/L y potasemia: 4,8 mEq/L. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener el tratamiento
B Suspender la metformina
C Suspender el diurético
D Suspender el enalapril
E Suspender el amlodipino

Respuesta B. Con creatinina de 3,8 mg/dL a los 78 años, la filtración está muy por debajo de 30 mL/min: la metformina está contraindicada por riesgo de acidosis láctica. Además, su HbA1c de 6 % indica sobretratamiento para su edad. El enalapril se mantiene: potasio normal y presión aún elevada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 18

Un paciente de 60 años, diabético tipo 2, en tratamiento con 500 mg de metformina al día, acude a control, con hemoglobina glicosilada de 8,8%, proteinuria (+) y claerence de creatinina de 50 ml/min. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Subir la dosis de metformina

B Agregar glibenclamida

C Agregar insulina NPH nocturna

D Tratar con mezcla de insulinas

E Agregar glipizida al tratamiento

Respuesta D. La insuficiencia renal contraindica los hipoglicemiantes orales: se debe dejar insulina. El tratamiento que tenía era pésimo.

▶ VER CLASE 1.02.1.010 Nefropatía incipiente

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 2.5 · Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal
Diabetes 5.1 · Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector

QUÉ HAY QUE SABER

- Albuminuria moderada (antigua microalbuminuria): RAC 30–299 mg/g en primera orina matinal; ≥300 es A3.
- Tamizaje: DM2 desde el diagnóstico y DM1 a los 5 años del debut, luego anual; la orina de 24 horas ya no es el estándar.
- Confirmar con 2 de 3 muestras positivas en 3–6 meses; descartar falsos positivos (ITU, fiebre, ejercicio intenso, hematuria, IC aguda).
- Tratamiento: IECA o ARA-II incluso en normotensos, a dosis máxima tolerada; nunca combinar ambos. Agregar iSGLT2 si VFG >20–25.
- Control intensivo de PA (<130/80), glicemia, lípidos (estatina) y suspender tabaco.
- Seguimiento completo en APS: RAC, creatinina y potasio periódicos; derivar si progresa a A3 o cae la VFG.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 54 años con DM2 de 7 años de evolución, en tratamiento con metformina, HbA1c 7,0 %, PA 124/76 mmHg. En su control anual se pide una muestra de orina matinal: razón albúmina/creatinina (RAC) de 48 mg/g. Creatinina 0,8 mg/dL, VFG 90 mL/min. No tiene fiebre, infección urinaria ni ha hecho ejercicio intenso. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Repetir la RAC hasta completar 2 de 3 muestras alteradas en 3 a 6 meses

B Iniciar losartán por nefropatía diabética

C Derivar a nefrología para biopsia renal

D Solicitar orina de 24 horas para proteinuria y repetir en un año

E Iniciar restricción proteica y control en un año

Respuesta A. La albuminuria varía mucho de un día a otro. La nefropatía incipiente (RAC 30–300 mg/g) se confirma con 2 de 3 muestras alteradas en un plazo de 3 a 6 meses, descartando infección, fiebre o ejercicio. Confirmada, se indica IECA o ARA II.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 53 años con DM2 hace 1 año, en metformina, HbA1c 6,8%, PA habitual 118/76 mmHg. En su control anual en el CESFAM: RAC 84 mg/g. Se repite a los 3 meses: 92 mg/g, con sedimento sin bacterias ni leucocitos. VFG estimada 85 ml/min/1,73 m². **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener el tratamiento, dado que es normotenso

B Iniciar enalapril y titular progresivamente

C Iniciar enalapril más losartán para un bloqueo doble

D Solicitar proteinuria de 24 horas antes de decidir

E Iniciar hidroclorotiazida

Respuesta B. Dos RAC en rango A2 (30–299 mg/g), sin falsos positivos: albuminuria persistente. Está indicado un IECA o ARA II aunque sea normotenso, porque dilata la arteriola eferente y baja la presión intraglomerular. Nunca IECA más ARA II. La orina de 24 horas ya no es el examen de elección.

▶ VER CLASE 1.02.1.011 Neuropatía diabética

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 5.3 · Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Polineuropatía distal simétrica sensitiva 'en calcetín': parestesias, ardor o dolor nocturno, pérdida de sensibilidad protectora; aquiliano abolido.
- Tamizaje anual con monofilamento 10 g (pulpejos 1.º, 3.º y 5.º y cabezas metatarsianas): un punto no percibido = pie de alto riesgo. Complementar con diapasón 128 Hz y pulsos.
- Componente motor (dedos en garra, cabezas metatarsianas prominentes) y autonómico (anhidrosis, piel seca e hiperqueratósica; gastroparesia, hipotensión ortostática, disfunción eréctil).
- Tratamiento inicial: optimizar control glicémico, educación y cuidado de pies; dolor neuropático con pregabalina, gabapentina, duloxetina o amitriptilina.
- No se pide electromiografía de rutina para el tamizaje; descartar déficit de B12 (metformina), hipotiroidismo y alcohol.

- Seguimiento: derivar si hay dolor refractario, formas atípicas (asimétricas, motoras) o úlcera.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 59 años con DM2 de 12 años de evolución, HbA1c 8,1 %. Asintomático. En su control anual en el CESFAM se examinan los pies: piel íntegra, sin deformidades, pulsos pedios presentes. No percibe el monofilamento de 10 g en 4 de 10 puntos plantares de cada pie y tiene la sensibilidad vibratoria disminuida con diapasón de 128 Hz. **¿Cuál es la interpretación y conducta más adecuada?**

A Polineuropatía diabética con pérdida de sensibilidad protectora: pie de alto riesgo, educación, calzado adecuado y controles frecuentes

B Examen normal; repetir en un año

C Enfermedad arterial periférica; solicitar índice tobillo-brazo urgente

D Iniciar pregabalina para prevenir úlceras

E Derivar a neurología para electromiografía antes de clasificar el riesgo

Respuesta A. La pérdida de sensibilidad al monofilamento de 10 g demuestra polineuropatía con pérdida de la sensibilidad protectora, el principal factor de riesgo de úlcera. Se clasifica como pie de riesgo: educación en autocuidado, calzado adecuado, podología y control más frecuente. La electromiografía no es necesaria y la pregabalina es solo para el dolor neuropático.

▶ VER CLASE 1.02.1.012 Obesidad

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.6 · Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Obesidad: IMC ≥30 kg/m² (sobrepeso 25–29,9); obesidad abdominal por circunferencia de cintura (≥90 cm hombre, ≥80 cm mujer en Chile).
- Evaluar comorbilidades: DM2, HTA, dislipidemia, hígado graso, apnea del sueño, artrosis; descartar hipotiroidismo y Cushing si la clínica sugiere.
- Tratamiento base: déficit de 500–1.000 kcal/día con dieta saludable, actividad física 150 min/semana aeróbica + fuerza 2–3 veces/semana, y terapia conductual. Meta inicial: bajar 5–10 % del peso en 6 meses.
- Fármacos si IMC ≥30, o ≥27 con comorbilidad: agonistas GLP-1 (liraglutida, semaglutida, baja 5–15 %) u orlistat; en el diabético obeso preferir metformina, GLP-1 o iSGLT2.
- Cirugía bariátrica si IMC ≥40, o ≥35 con comorbilidad, tras falla del manejo médico.
- Seguimiento completo: peso, cintura, PA, glicemia y lípidos periódicos; mantener la baja de peso a largo plazo.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 20

Un adolescente de 16 años, con IMC de 33, se realiza una glicemia de ayuno, que resulta 96 mg/dl, más una insulina basal que resulta 23 UI/L. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar insulina

B Iniciar dieta y ejercicio

C Iniciar metformina

D Solicitar un test de tolerancia a la glucosa

E Iniciar metformina más glibenclamida

Respuesta B. HOMA-IR = 96 × 23 / 405 ≈ 5,5 (> 2,6): resistencia a la insulina. La glicemia de ayuno es normal (< 100), así que no hay diabetes ni glicemia alterada: dieta y ejercicio.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 20

Un adolescente de 16 años, con IMC de 33 kg/m², se realiza una glicemia de ayuno que resulta 96 mg/dL y una insulinemia basal de 23 µUI/mL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar insulina

B Iniciar dieta y ejercicio

C Iniciar metformina

D Solicitar un test de tolerancia a la glucosa

E Iniciar metformina más glibenclamida

Respuesta B. Tiene obesidad con resistencia a la insulina (HOMA = 96 × 23 / 405 ≈ 5,5), pero glicemia de ayuno normal, sin diabetes ni prediabetes. El manejo es el cambio de estilo de vida: dieta y actividad física, idealmente con apoyo familiar. La metformina no se indica solo por insulinemia alta en un adolescente.

▶ VER CLASE 1.02.1.013 Obesidad mórbida

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.6 · Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Obesidad mórbida (clase III): IMC ≥40 kg/m², o ≥35 con comorbilidad grave (DM2, HTA, apnea del sueño, artrosis invalidante).
- Sospechar complicaciones: apnea obstructiva del sueño (ronquido, somnolencia), síndrome de hipoventilación, hígado graso, insuficiencia cardíaca, depresión.

- Manejo inicial: estilo de vida intensivo (dieta hipocalórica, actividad física adaptada) y control de comorbilidades; tamizar DM2, dislipidemia y HTA.
- Indicación de cirugía bariátrica (manga gástrica o bypass gástrico) si IMC ≥40, o ≥35 con comorbilidad, tras falla de tratamiento médico.
- Seguimiento: derivar a equipo multidisciplinario de obesidad/cirugía bariátrica; tras la cirugía suplementar hierro, B12, calcio y vitamina D.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 38 años, con IMC de 42 kg/m², hipertensa y con DM2, ha intentado bajar de peso por más de 2 años con dieta, ejercicio y apoyo farmacológico, sin éxito. No tiene trastorno psiquiátrico descompensado ni consumo de alcohol o drogas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Insistir solo con dieta hipocalórica estricta

B Indicar liposucción

C Indicar ayuno intermitente prolongado

D Iniciar levotiroxina para aumentar el gasto energético

E Derivar a evaluación multidisciplinaria para cirugía bariátrica

Respuesta E. Con IMC ≥40 kg/m², o ≥35 con comorbilidades, y fracaso del tratamiento médico, la cirugía bariátrica (manga gástrica o bypass) es la terapia más eficaz para bajar de peso en forma sostenida y mejora la diabetes y la HTA. Requiere evaluación multidisciplinaria previa. La liposucción no trata la obesidad ni sus comorbilidades.

▶ VER CLASE 1.02.1.014 Pié diabético y otras infecciones en diabetes

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 5.3 · Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico
Otorrino 14.3 · Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Pie diabético: neuropatía (>80 %) + isquemia + traumatismo. Úlcera neuropática indolora en zona de apoyo con pulsos presentes; isquémica dolorosa, distal y con pulsos ausentes.
- Clasificación de Wagner: 0–2 ambulatorio (descarga + curación avanzada); 3–5 (absceso, osteomielitis, gangrena) hospitalizar. Estilete que toca hueso = osteomielitis (Wagner 3).
- Cultivo de tejido profundo o biopsia ósea, nunca hisopado superficial. Radiografía o RM si sospecha osteomielitis; pulsos ausentes: índice tobillo-brazo.
- Antibióticos: leve (celulitis <2 cm) cefadroxilo o cloxacilina VO 7–14 días; moderada amoxicilina-clavulánico o ciprofloxacino + clindamicina; severa ceftriaxona + metronidazol EV.
- Otras infecciones típicas del diabético: otitis externa maligna (anciano, Pseudomonas, granulación en piso del conducto; ciprofloxacino o ceftazidima EV 6–8 semanas), mucormicosis, pielonefritis enfisematosa.
- Seguimiento: derivar Wagner ≥3, gangrena o isquemia (estudio vascular antes de resecar).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 93

DM con polineuropatía, dedos en garra, hiperqueratosis, con test de monofilamento alterado, pulsos disminuidos, conducta: **¿Cuál es la conducta?**

A Mejorar calzado

B Electromiografia, realizar test de nuevo en unos meses

C Observación clínica

D Derivar a urgencia

E Control ambulatorio

Respuesta A. Pie de riesgo sin úlcera (dedos en garra, hiperqueratosis, monofilamento alterado): Wagner 0. La conducta es preventiva: calzado adecuado, educación y podología. No es una urgencia y no requiere electromiografía.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 74 años, con diabetes mellitus tipo 2 de 20 años y mal control (HbA1c 10,2%), consulta por otalgia izquierda progresiva de 3 semanas, intolerable en las últimas noches. Recibió dos ciclos de gotas óticas de polimixina y neomicina sin mejoría. Presenta asimetría facial izquierda, con imposibilidad para ocluir el ojo izquierdo. En la otoscopía hay secreción purulenta fétida y tejido de granulación rojizo y friable en el piso del conducto, en la unión osteocartilaginosa. **¿Cuál es la conducta de elección?**

A Gotas óticas de ciprofloxacino con dexametasona por 10 días y control ambulatorio

B Hospitalización, TAC de peñasco con contraste, control de glicemia y ciprofloxacino o ceftazidima endovenosos por al menos 6 a 8 semanas

C Amoxicilina con ácido clavulánico oral por 10 días

D Corticoides orales para la parálisis facial y control en una semana

E Aseo del conducto y observación

Respuesta B. Es una otitis externa maligna: anciano diabético descompensado, dolor nocturno refractario, granulación en el piso del conducto y parálisis facial. Requiere hospitalización, TAC con contraste, control de glicemia, cultivo y antibiótico endovenoso antipseudomonas por 6 a 8 semanas.

▶ VER CLASE 1.02.1.015 Retinopatía diabética

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 5.2 · Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES
Oftalmología 15.12 · Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Enfermedad silenciosa: se busca con fondo de ojo o retinografía no midriática, en DM2 al diagnóstico y luego anual; en DM1 desde los 5 años del debut (GES).
- Lesión más precoz: microaneurismas. No proliferativa: microhemorragias, exudados duros (fuga) y algodonosos (isquemia); severa por regla 4-2-1.
- Proliferativa: definida por neovasos en papila o retina; complicaciones hemorragia vítrea, desprendimiento traccional y glaucoma neovascular.
- Pérdida visual súbita e indolora con rojo pupilar abolido = hemorragia vítrea: derivar de inmediato. Edema macular: causa más frecuente de baja visual moderada, en cualquier etapa.
- Manejo inicial: control estricto de HbA1c y PA; derivar a oftalmología. Tratamientos GES: panfotocoagulación láser (proliferativa) y anti-VEGF intravítreo (edema macular).
- Seguimiento: derivar; anual si no hay retinopatía o es leve, más frecuente en etapas avanzadas.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 63 años con DM2 de 14 años de evolución, HbA1c 8,4 %, hipertensa. Consulta por visión borrosa progresiva del ojo derecho de 3 meses, sin dolor ni ojo rojo. Agudeza visual 20/60 en el ojo derecho. El fondo de ojo muestra microaneurismas, exudados duros en anillo y engrosamiento retinal que compromete el centro de la fóvea, sin neovasos. La tomografía de coherencia óptica confirma edema macular. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A Panfotocoagulación con láser
B Inyecciones intravítreas de anti-VEGF
C Vitrectomía
D Solo optimizar el control glicémico y repetir fondo de ojo en un año
E Corticoides tópicos

Respuesta B. El edema macular es la causa más frecuente de baja visual moderada en la diabetes. Cuando compromete el centro de la fóvea, la primera línea son las inyecciones intravítreas de anti-VEGF (ranibizumab, aflibercept). La panfotocoagulación con láser se reserva para la retinopatía proliferativa, con neovasos.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años, con diabetes mellitus tipo 2 de 10 años de evolución y mal control metabólico, acude a control en atención primaria asintomático, refiriendo que ve perfectamente. Se realiza fondo de ojo bajo dilatación pupilar, evidenciándose múltiples microaneurismas, exudados duros en el polo posterior y neovasos finos que crecen sobre el disco de la papila óptica derecha. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tranquilizar al paciente: si no tiene síntomas, no hay retinopatía significativa
B Indicar solo optimizar el control glucémico y repetir el fondo de ojo en un año
C Notificar GES 23 y derivar de forma prioritaria para panfotocoagulación láser
D Iniciar corticoides tópicos y controlar en tres meses
E Solicitar únicamente una angiografía y esperar el resultado sin derivar

Respuesta C. La presencia de neovasos sobre la papila óptica en un paciente diabético define la retinopatía diabética proliferativa, aunque esté asintomático. La conducta es notificar la garantía GES 23 y derivar de forma prioritaria a panfotocoagulación láser, por el riesgo inminente de hemorragia vítrea o desprendimiento traccional.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 124

pte diabetico con fondo de ojo alterado tenia buen control metabolico, cual era la medida mas adecuada

A Pioglitazona
B Sitagliptina
C Insulina NPH
D Glibenclamida
E subir metformina??

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Glibenclamida). subir metformina??. La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera adquirida en adultos en edad laboral.

▶ VER CLASE 1.02.1.016 Síndrome metabólico

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 5.6 · Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico (ATP III): 3 o más de 5 criterios: cintura ≥90 cm hombre / ≥80 cm mujer, PA ≥130/85, glicemia de ayuno ≥100, TG ≥150, HDL <40 en hombres o <50 en mujeres.
- Eje fisiopatológico: resistencia a la insulina; marcadores clínicos acantosis nigricans y acrocordones. HOMA-IR >2,6 indica resistencia.
- Implica alto riesgo de DM2 y enfermedad cardiovascular; evaluar hígado graso, apnea del sueño y síndrome de ovario poliquístico.
- Tratamiento: cambio intensivo del estilo de vida (baja de 5–10 % del peso, dieta mediterránea, 150 min/semana de ejercicio); es la intervención más efectiva.
- Tratar cada componente según metas: estatina si el riesgo lo indica, antihipertensivos, metformina si hay prediabetes de alto riesgo.

- Seguimiento completo en APS: peso, cintura, PA, glicemia y perfil lipídico periódicos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 42

Un paciente de 30 años, con IMC de 30 kg/m², consulta por hiperpigmentación de la piel de las axilas y el cuello, asociada a la aparición de acrocordones en los pliegues inguinales, cervicales y axilares. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Enfermedad de Cushing
B Hipotiroidismo
C Síndrome paraneoplásico
D Insuficiencia suprarrenal
E Resistencia a la insulina

Respuesta E. La acantosis nigricans en pliegues con acrocordones en un paciente obeso es el marcador cutáneo clásico de resistencia a la insulina, eje del síndrome metabólico. La forma paraneoplásica es rara, brusca, extensa y en mayores que bajan de peso. La insuficiencia suprarrenal hiperpigmenta mucosas y cicatrices, sin acrocordones.

▶ VER CLASE 1.02.1.017 Síndromes carenciales de vitaminas y minerales

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.19 · Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo

QUÉ HAY QUE SABER

- Déficit de vitamina D: medir 25(OH)D (no calcitriol). <20 ng/mL deficiencia, 20–29 insuficiencia, 30–50 suficiente. Riesgo: adulto mayor institucionalizado, sin sol, malabsorción.
- Osteomalacia: dolor óseo, miopatía proximal, FA alta, fósforo bajo, PTH alta; líneas de Looser-Milkman. Tratar con colecalciferol 50.000 UI semanal por 8 semanas y luego 1.000–2.000 UI/día + calcio.
- Déficit de B12: anemia macrocítica, glositis, neuropatía y deterioro cognitivo; causas anemia perniciosa, metformina, gastrectomía, veganismo. Reponer B12 IM.
- Déficit de hierro (anemia microcítica, ferritina baja) y de ácido fólico (macrocítica, alcohol, embarazo); tiamina: Wernicke y beriberi en alcohólicos.
- Otros: zinc (dermatitis acral, diarrea), vitamina A (ceguera nocturna), vitamina C (escorbuto, encías sangrantes), vitamina K (coagulopatía en malabsorción).
- Seguimiento: buscar y tratar la causa; derivar si hay malabsorción o déficit sin causa clara. No iniciar bifosfonatos antes de reponer vitamina D.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 78 años, residente de un ELEAM en Valdivia, sin exposición solar. Astenia, dolor difuso en pelvis y piernas, debilidad proximal y marcha anadeante. Ca 8,4 mg/dL (albúmina 3,9), P 2,0 mg/dL, FA 340 U/L (VN < 120), PTH 115 pg/mL, 25(OH)D 8 ng/mL. Rx de pelvis: bandas radiolúcidas perpendiculares a la cortical en ambos cuellos femorales. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Alendronato 70 mg semanal más calcio
B Colecalciferol 50.000 UI semanal por 8 semanas más calcio 1.000 mg/día
C Colecalciferol 800 UI/día sin calcio
D Paratiroidectomía
E Solicitar 1,25(OH)2D antes de tratar

Respuesta B. Dolor óseo, miopatía proximal, P bajo, FA y PTH altas, 25(OH)D de 8 y líneas de Looser-Milkman: osteomalacia por déficit severo de vitamina D. Carga de colecalciferol 50.000 UI semanal por 8 semanas con calcio, y luego mantención 1.000–2.000 UI/día. Los bifosfonatos están contraindicados en la osteomalacia no corregida.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 23

Una paciente de 64 años, con antecedente de by-pass gástrico, por obesidad mórbida, presenta un cuadro de dificultad a la marcha, asociado a astenia y malestar general. En sus exámenes destaca anemia macrocítica, plaquetas: 100.000 por mm3, blancos: 6.000 por mm3, ferritina 56 ug/dl y saturación de transferrina de 18%. ¿El déficit de qué nutriente explica mejor este caso?

A Fierro
B Ácido fólico
C Cianocobalamina
D Zinc
E Tiamina

Respuesta C. Tiene un déficit de B12, tanto por el antecedente de by-pass como por la macrocitosis y plaquetopenia. La ferritina está normal (VN: 15 a 300).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 25

Una paciente de 34 años, con antecedente de by pass gástrico hace 2 años, por obesidad mórbida, consulta por astenia, disnea y marcada fatigabilidad y debilidad de extremidades inferiores. Al examen físico tiene paresia M4 de ambas extremidades inferiores, con disminución de la sensibilidad distal e hiporreflexia. Se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 7,0 g/dl, hematocrito: 20%, glóbulos blancos: 3.100 por mm3 y plaquetas: 93.000 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Desnutrición proteica
B Déficit de zinc
C Déficit de fosfatos
D Déficit de niacina
E Déficit de cianocobalamina

Respuesta E. Es un déficit de B12 clásico. Recordar que el déficit de B6 (piridoxina) es el causado por el consumo crónico de isoniazida (ej. TBC o PFX TBC) y se presenta como una polineuropatía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 11

Una paciente de 25 años, vegetariana estricta, con antecedente de un hijo con mielomeningocele, presenta anemia. ¿Cuál es la indicación más adecuada?

A Vitamina B12
B Folatos
C Tiamina
D Ácidos grasos omega 3
E Aminoácidos esenciales

Respuesta B. Por ser vegetariana también debe recibir B12, pero los folatos son lo más importante por el mielomeningocele (defecto del tubo neural)

▶ VER CLASE 1.02.1.018 Trastornos de conducta alimentaria

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.6 · Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Anorexia nerviosa: restricción de ingesta con peso significativamente bajo, miedo intenso a engordar y distorsión de la imagen corporal; subtipos restrictivo y purgativo.
- Bulimia nerviosa: atracones recurrentes con conductas compensatorias (vómitos, laxantes, ejercicio) al menos 1 vez/semana por 3 meses, con peso habitualmente normal; signo de Russell, hipertrofia parotídea, erosión dental.
- Trastorno por atracón: atracones sin conductas compensatorias, asociado a obesidad.
- Evaluar gravedad: IMC (<15 extrema), bradicardia, hipotensión, hipotermia, hipokalemia, alcalosis metabólica (vómitos), QT largo, amenorrea, osteopenia.
- Hospitalizar si FC <40–50, PA muy baja, hipokalemia, IMC muy bajo, ideación suicida o falla del tratamiento ambulatorio; realimentar lento por riesgo de síndrome de realimentación (hipofosfemia).
- Seguimiento: derivar a psiquiatría/equipo multidisciplinario (psicoterapia, nutrición; ISRS como fluoxetina en bulimia).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una adolescente de 17 años es traída por su madre, que encontró envoltorios de comida escondidos. Refiere episodios de ingesta de grandes cantidades de comida con sensación de pérdida de control, 3 veces por semana desde hace 4 meses, seguidos de vómitos autoinducidos. Su IMC es 22 kg/m². Al examen tiene hipertrofia parotídea y callosidades en el dorso de la mano. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Anorexia nerviosa restrictiva
B Trastorno de rumiación
C Trastorno por atracón
D Bulimia nerviosa
E Trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos

Respuesta D. Atracones con pérdida de control y conductas compensatorias (vómitos) al menos una vez por semana durante 3 meses, con peso normal, definen bulimia nerviosa; la hipertrofia parotídea y el signo de Russell son típicos. En el trastorno por atracón no hay conductas compensatorias y en la anorexia el peso es bajo. Se debe controlar el potasio.

▶ VER CLASE 1.02.1.019 Vasculopatía periférica

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.3 · Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Enfermedad arterial periférica: claudicación intermitente (dolor en pantorrilla al caminar que cede con reposo); en el diabético puede ser silente por la neuropatía.
- Signos: pulsos pedio y tibial posterior disminuidos o ausentes, palidez al elevar y rubor al declive, piel fría, atrófica, sin vello; úlcera isquémica distal dolorosa.
- Sospecha confirmada con índice tobillo-brazo <0,9 (en el diabético puede salir falsamente alto >1,3 por calcificación).

- Isquemia crítica (dolor de reposo, úlcera o gangrena) o isquemia aguda (6 P: dolor, palidez, ausencia de pulsos, parestesias, parálisis, poiquilotermia): derivación urgente a cirugía vascular.
- Manejo inicial: suspender tabaco, ejercicio supervisado, AAS o clopidogrel, estatina de alta intensidad, control de PA y glicemia; cilostazol para la claudicación.
- Seguimiento: derivar a cirugía vascular para eco-Doppler/angiografía y evaluar revascularización.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 64 años, diabético y fumador, refiere dolor en ambas pantorrillas al caminar 200 metros, que cede a los pocos minutos de reposo. Los pulsos pedios están disminuidos y el índice tobillo-brazo es 0,7. **¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A Cesación tabáquica, ejercicio supervisado, estatina y antiagregante plaquetario

B Revascularización quirúrgica inmediata

C Anticoagulación oral

D Amputación infracondílea

E Reposo absoluto en cama

Respuesta A. Claudicación intermitente con ITB bajo 0,9 confirma enfermedad arterial periférica. El manejo inicial es reducir el riesgo cardiovascular (dejar de fumar, estatina de alta intensidad, antiagregante, control de diabetes y PA) más ejercicio supervisado, que aumenta la distancia de marcha. La revascularización se reserva para isquemia crítica o claudicación invalidante.

Situaciones clínicas de urgencia

7 códigos

▶ VER CLASE **1.02.2.001** **Acidosis láctica**

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 2.2 · Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas

QUÉ HAY QUE SABER

- Acidosis metabólica con anion gap aumentado y lactato >4–5 mmol/L; la asociada a metformina tiene mortalidad 40–50 %.
- Gatillantes: hipoperfusión o hipoxemia (shock, sepsis, IC, IRA) en paciente usuario de metformina, sobre todo con VFG <30, falla hepática o alcohol; también contraste yodado.
- Clínica: náuseas, vómitos, dolor abdominal, taquipnea (Kussmaul), compromiso de conciencia, hipotensión.
- Manejo inicial: suspender metformina, soporte hemodinámico con fluidos y oxigenación, tratar la causa; hemodiálisis en casos graves (elimina la metformina).
- Prevención: suspender metformina con VFG <30, 48 h antes de contraste o cirugía, y al hospitalizarse por sepsis o hipoxemia.
- Seguimiento: derivar a UPC; no reiniciar metformina hasta recuperar función renal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 71 años con DM2 en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas desde hace 8 años, sin controles recientes. Consulta por 3 días de vómitos, dolor abdominal difuso y decaimiento. Está taquipneico, con respiración profunda, PA 95/60 mmHg. Glicemia 165 mg/dL, cetonemia negativa, creatinina 3,4 mg/dL (VFG 18 mL/min), pH 7,08, HCO3 7 mEq/L, anión gap 26, lactato 11 mmol/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Cetoacidosis diabética

B Hipoglicemia por metformina

C Estado hiperglicémico hiperosmolar

D Acidosis tubular renal

E Acidosis láctica asociada a metformina

Respuesta E. Acidosis metabólica grave con anión gap elevado, lactato alto, cetonas negativas y glicemia casi normal en un usuario de metformina con falla renal: acidosis láctica asociada a metformina. Se suspende la metformina y la hemodiálisis corrige la acidosis y elimina el fármaco.

▶ VER CLASE **1.02.2.002** **Cetoacidosis**

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 4.1 · Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)
Diabetes 4.2 · Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH
Diabetes 4.3 · Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato
Diabetes 4.4 · Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea
Diabetes 4.5 · Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia

QUÉ HAY QUE SABER

- Criterios: glicemia >250 mg/dL, pH <7,30 y HCO_3 <18 mEq/L, anion gap >10–12 y cetonas positivas (β-hidroxibutirato >3 mmol/L). Severa si pH <7,00 o HCO_3 <10 (UCI).
- Joven DM1 (debut o abandono de insulina), instalación <24 h: dolor abdominal y vómitos que simulan abdomen agudo, Kussmaul y aliento cetósico. Buscar gatillante: infección la n.º 1. Con iSGLT2 puede ser euglicémica.
- Hora 1: suero fisiológico 1.000–1.500 mL (15–20 mL/kg), antes que la insulina; luego NaCl 0,45 % si Na corregido ≥135 o 0,9 % si <135. Reponer el déficit (3–6 L) en 24–48 h.

- Potasio antes de la insulina: K <3,3 no dar insulina y reponer KCl 20–30 mEq/h; 3,3–5,2 insulina + KCl; >5,2 insulina sola. Insulina cristalina EV 0,1 UI/kg/h; meta bajar 50–75 mg/dL/h.
- Con glicemia ≤200 agregar SG 5 % y bajar la insulina a la mitad, sin suspenderla. Bicarbonato solo si pH <6,90.
- Resuelta con glicemia <200 + 2 de 3 (HCO_3 ≥18, pH venoso >7,30, AG ≤12); insulina basal SC 1–2 h antes de apagar la bomba. Vigilar edema cerebral (niños, 4–12 h). Seguimiento: derivar.

PREGUNTAS · 10

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 16

Un joven de 14 años, deportista de alto rendimiento, consulta por un cuadro de poldipsia y poliuria de 3 semanas de evolución, al que hace 7 días se agrega astenia, náuseas y malestar general. Refiere marcada debilidad, después de realizar ejercicio. Se solicitan exámenes, en las que destaca glicemia: 312 mg/dl, Na+: 132 mEq/L, K+: 5,0 mEq/L, pH sanguíneo: 7,26, bicarbonato plasmático: 11 mEq/L, exceso de base: -13. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hiperglicemia secundaria al ejercicio

B Cetoacidosis diabética

C Debut de diabetes tipo 2

D Diabetes insípida descompensada

E Coma hiperosmolar

Respuesta B. Glicemia > 250 mg/dL con acidosis metabólica (pH < 7,30 y HCO_3 < 18) en un adolescente con síntomas cardinales: cetoacidosis diabética como debut de una DM1. No es hiperosmolar: la glicemia es < 600 y hay acidosis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 54

Un paciente de 20 años presenta un cuadro de poliuria y polidipsia, de 2 días de evolución, a lo que se ha agregado dolor abdominal y vómitos hace pocas horas. Se solicita una glicemia, que resulta 360 mg/dl. **¿Qué examen es más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?**

A Cetonemia

B Creatininemia

C Perfil lipídico

D Hemoglobina glicosilada

E Hemograma

Respuesta A. Joven con síntomas cardinales, dolor abdominal, vómitos y glicemia > 250: sospecha de cetoacidosis. Lo urgente es confirmarla con cetonemia (junto con gases venosos). La HbA1c no cambia la conducta en la urgencia.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 24 años con DM1, en tratamiento por cetoacidosis diabética severa. Recibió 1.500 ml de NaCl 0,9% en la primera hora y luego insulina cristalina en infusión. A las 5 horas: hemoglucotest 188 mg/dL, pH 7,21, HCO_3 12 mEq/L, anion gap 18 mEq/L. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Suspender la infusión de insulina hasta que la glicemia vuelva a subir

B Agregar suero glucosado al 5% y reducir la infusión de insulina a la mitad

C Pasar a insulina NPH subcutánea y suspender los fluidos

D Mantener la misma infusión de insulina con NaCl 0,9%

E Administrar bicarbonato para corregir el pH y suspender la insulina

Respuesta B. La glicemia ya está ≤ 200 mg/dL, pero la cetoacidosis no está resuelta (pH < 7,30, HCO_3 < 18, gap abierto). Se mantiene la insulina a menor dosis (0,02–0,05 UI/kg/h) y se agrega SG 5% para evitar la hipoglicemia mientras se cierra el gap.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 24 años con DM1, hospitalizado hace 10 horas por cetoacidosis diabética, con insulina cristalina EV en bomba. Control: glicemia 165 mg/dL, pH venoso 7,21, bicarbonato 12 mEq/L, anion gap 19 mEq/L, K 4,3 mEq/L. Está somnoliento y con náuseas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Suspender la bomba, ya que la glicemia es menor de 200 mg/dL

B Inyectar glargina subcutánea y apagar la bomba en ese mismo momento

C Mantener la insulina EV y agregar suero glucosado al 5%

D Administrar bicarbonato de sodio para cerrar el anion gap

E Cambiar a insulina cristalina subcutánea según hemoglucotest

Respuesta C. La glicemia está bajo 200, pero no cumple ninguno de los tres criterios ácido-base (pH 7,21, HCO3 12, anion gap 19) y no tolera vía oral: la cetoacidosis no está resuelta. Se mantiene la insulina EV y se agrega SG 5% para sostener la glicemia en 150–200 mg/dL. No hay traslape sin resolución, y el pH de 7,21 no indica bicarbonato.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 19 años con DM1 evoluciona favorablemente de un episodio de cetoacidosis diabética. Sus exámenes de control muestran: glicemia 168 mg/dL, pH venoso 7.33, bicarbonato 19 mEq/L y Anion Gap 11 mEq/L. Se encuentra lúcido y solicita alimentarse. **¿Cuál es el procedimiento correcto para suspender la bomba de insulina endovenosa y realizar la transición a insulina subcutánea?**

A Suspender la bomba de infusión endovenosa inmediatamente y esperar 4 horas antes de aplicar la primera dosis subcutánea

B Inyectar la primera dosis de insulina basal subcutánea y apagar la bomba endovenosa simultáneamente en ese mismo instante

C Administrar la dosis de insulina basal subcutánea y mantener la infusión endovenosa durante 1 a 2 horas más antes de suspenderla

D Administrar solo insulina ultrarrápida subcutánea cuando la glicemia supere los 250 mg/dL en controles posteriores

E Mantener la bomba de insulina endovenosa por 48 horas adicionales sin aportar alimentos por boca

Respuesta C. Cumple los criterios de resolución y tolera la vía oral. Como la insulina EV tiene vida media de 5 a 9 minutos y la basal SC tarda 1 a 2 horas en absorberse, se inyecta la basal y la bomba se mantiene 1 a 2 horas más. Apagarla junto con el pinchazo deja un hueco sin insulina y una cetoacidosis de rebote.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

¿Cuál de los siguientes conjuntos de parámetros gasométricos y de laboratorio certifica de manera indiscutida la resolución de una Cetoacidosis Diabética en un adulto? **Elige una alternativa.**

A Glicemia de 220 mg/dL, pH 7.26, bicarbonato 14 mEq/L y cetonuria negativa

B Glicemia de 180 mg/dL, pH venoso 7.32, bicarbonato 19 mEq/L y Anion Gap de 10 mEq/L

C Glicemia de 140 mg/dL, pH venoso 7.18, bicarbonato 12 mEq/L y glucosuria negativa

D Glicemia de 95 mg/dL con cetonuria persistente +++ y pH 7.20

E Glicemia de 250 mg/dL con osmolaridad de 290 mOsm/kg y bicarbonato de 15 mEq/L

Respuesta B. Resolución de CAD: glicemia menor de 200 mg/dL y al menos 2 de 3: pH venoso mayor de 7,30, bicarbonato de 18 mEq/L o más y anion gap de 12 o menos. Solo la B los cumple. C y D tienen glicemias más bajas, pero siguen acidóticas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 20 años con DM1 en tratamiento por cetoacidosis diabética, con insulina cristalina EV y suero fisiológico. A las 7 horas se torna confusa, sudorosa y temblorosa. PA 118/72 mmHg, FC 112 lpm. Hemoglucotest: 48 mg/dL. Nunca se agregó suero glucosado a la hidratación. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Manitol al 20% EV y reducir la velocidad de los fluidos

B TAC de cerebro urgente

C Glucosa al 30% EV en bolo y agregar suero glucosado al 5%

D Fosfato de potasio EV

E Bicarbonato de sodio EV

Respuesta C. Confusión con diaforesis, temblor, taquicardia y glicemia de 48 mg/dL: hipoglicemia por no agregar SG 5% al bajar la glicemia manteniendo la insulina. Se trata con glucosa al 30% EV en bolo (20–50 ml) y se agrega SG 5%. No hay tríada de Cushing: la presión es normal y la frecuencia está alta, no baja.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un adolescente de 13 años se encuentra hospitalizado en la UCI recibiendo tratamiento para una cetoacidosis diabética severa. A las 6 horas de iniciada la fluidoterapia y la insulina endovenosa, el paciente refiere cefalea intensa y presenta dos vómitos explosivos, tornándose progresivamente somnoliento y desorientado. Al monitor se observa un ascenso de la PA de 105/65 a 140/90 mmHg y un descenso de la FC de 102 a 54 lpm. **¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?**

A Trasladar de urgencia a tomografía axial computarizada de encéfalo para confirmar el diagnóstico

B Administrar inmediatamente Manitol al 20% por vía endovenosa (o Solución Salina al 3%) y reducir la velocidad de los fluidos

C Aumentar la velocidad de infusión de suero fisiológico para tratar el shock hipovolémico

D Indicar una dosis de atropina endovenosa para revertir la bradicardia sinusal

E Suspender la insulina y administrar 4 ampollas de glucosa al 30% en bolo

Respuesta B. Edema cerebral con respuesta de Cushing (hipertensión y bradicardia, con cefalea, vómitos explosivos y deterioro de conciencia) a las 6 horas de tratamiento. Manitol al 20% (0,5–1 g/kg EV en 20 minutos) o NaCl 3% (5 ml/kg) de inmediato, al lado de la cama, y reducir los fluidos. Retrasar el tratamiento por una TAC arriesga la herniación.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 28 años hospitalizado en tratamiento de cetoacidosis diabética presenta debilidad muscular generalizada profunda e insuficiencia ventilatoria aguda con incapacidad para sostener el esfuerzo inspiratorio tras 18 horas de evolución. Sus exámenes demuestran: glicemia 170 mg/dL, pH 7.35, bicarbonato 20 mEq/L, sodio 138 mEq/L, potasio 4.2 mEq/L, calcio 9.2 mg/dL y fósforo inorgánico de 0.8 mg/dL. **¿Cuál es el tratamiento específico indicado?**

A Gluconato de calcio al 10% endovenoso

B Sulfato de magnesio endovenoso

C Suplementación endovenosa con Fosfato de Potasio

D Aumento de la dosis de insulina cristalina

E Bicarbonato de sodio al 2/3 molar

Respuesta C. Hipofosfemia severa sintomática (fósforo 0,8 mg/dL, menor de 1,0): el fósforo es necesario para el ATP y el 2,3-DPG, y su déficit produce debilidad diafragmática y falla ventilatoria. Con potasio y calcio normales, el tratamiento específico es fosfato de potasio EV en infusión lenta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 101

Cetoacidosis cetonas (+) pH 7.1 K 3 conducta inicial hidratar SF

A Observación clínica

B Derivar a urgencia

C Control ambulatorio

D Solicitar exámenes complementarios

E Hospitalizar para estudio

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Observación clínica (opción A). PaO2 normal: 75-100 mmHg. Hipoxemia: < 75 mmHg. Insuficiencia respiratoria: < 60 mmHg (equivale aprox. a SatO2 90%).

▶ VER CLASE 1.02.2.003 Coma hiperosmolar

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 4.1 · Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)
Diabetes 4.2 · Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH

QUÉ HAY QUE SABER

- Estado hiperglicémico hiperosmolar: adulto mayor DM2, instalación insidiosa en días a semanas con poliuria, deshidratación extrema (8–12 L) y compromiso de conciencia (puede simular ACV).
- Criterios: glicemia >600 mg/dL, osmolaridad efectiva >320 mOsm/kg (2×Na + glicemia/18), pH >7,30, HCO_3 >18 y cetonas ausentes o trazas.
- Buscar gatillante: infección (neumonía, ITU), IAM, ACV, corticoides, omisión de tratamiento.
- Manejo inicial: volumen primero, SF 0,9 % 1.000–1.500 mL la primera hora; luego según Na corregido. Insulina EV 0,1 UI/kg/h tras hidratar y con K ≥3,3; SG 5 % cuando la glicemia llegue a 300.
- Corrección lenta: osmolaridad ≤3 mOsm/kg/h y déficit en 24–48 h para evitar edema cerebral. Resuelto con osmolaridad <315, glicemia <250–300 y paciente lúcido.
- Seguimiento: no requiere seguimiento específico de la crisis; continuar el control de su diabetes (habitualmente con insulina) tras el alta.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 39

Un paciente de 70 años presenta un cuadro de malestar general y poliuria de dos semanas de evolución, agregándose desorientación y compromiso de conciencia cuantitativo en las últimas 48 horas. En su examen, no presenta focalidad neurológica y sus laboratorios revelan glicemia: 950 mg/dL, pH venoso: 7,37, bicarbonato: 18 mEq/L, cetonemia (-), cetonuria (+), sodio plasmático: 149 mEq/L y potasio plasmático: 5,0 mEq/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Coma hiperosmolar no cetósico

B Cetoacidosis diabética

C Síndrome hiperglicémico mixto (hiperosmolar + cetoacidosis)

D Hipernatremia sintomática

E Edema cerebral

Respuesta A. Adulto mayor, dos semanas de poliuria, compromiso de conciencia, glicemia > 600 sin acidosis (pH 7,37) y cetonemia negativa. Osmolaridad efectiva: 2 × 149 + 950/18 ≈ 351 mOsm/kg (> 320). Una cetonuria aislada no hace una cetoacidosis.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 80 años con DM2, ingresada en coma por estado hiperglicémico hiperosmolar: glicemia 950 mg/dL, Na 142 mEq/L, osmolaridad efectiva 360 mOsm/L, sin cetosis. Recibió 4 litros de suero fisiológico en 3 horas e insulina en bomba a 0,14 UI/kg/h, sin agregar suero glucosado. A las 6 horas la glicemia es de 210 mg/dL; tras recuperar parcialmente la conciencia, presenta cefalea, bradicardia, vómitos y una convulsión tónico-clónica. **¿Cuál es la causa más probable del deterioro?**

A Hipoglicemia por la infusión de insulina

B Accidente cerebrovascular hemorrágico por hipertensión

C Hipernatremia por el suero fisiológico

D Cetoacidosis diabética sobreagregada

E Edema cerebral por descenso demasiado rápido de la osmolaridad

Respuesta E. En el coma hiperosmolar la neurona se adaptó al medio hiperosmolar. Si la glicemia y la osmolaridad caen bruscamente (aquí 740 mg/dL en 6 horas), el agua entra a la célula y aparece edema cerebral. La glicemia debe bajar 50 a 75 mg/dL por hora, con suero glucosado al llegar a 300 mg/dL.

▶ VER CLASE 1.02.2.004 Déficit agudo de tiamina

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Psiquiatría 17.15 · Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

QUÉ HAY QUE SABER

- Encefalopatía de Wernicke por déficit de tiamina (B1): alcohólico crónico, desnutrición, hiperémesis, cirugía bariátrica o realimentación.
- Tríada: oftalmoplejía/nistagmo (VI par), ataxia de la marcha y síndrome confusional; puede aparecer en cualquier momento, no solo en la abstinencia. Diagnóstico clínico.
- Regla de oro: tiamina EV o IM antes (o junto) de cualquier suero glucosado; la glucosa sola consume la tiamina y precipita el daño de cuerpos mamilares.

- Tratamiento: tiamina parenteral en dosis altas (200–500 mg EV cada 8 h por 3–5 días en Wernicke establecido; profilaxis 100–300 mg/día), luego oral; corregir magnesio.
- Sin tratamiento evoluciona a síndrome de Korsakoff (amnesia anterógrada y confabulación), irreversible.
- Seguimiento: derivar para manejo de la dependencia alcohólica (naltrexona, disulfiram, apoyo psicosocial) y nutricional.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 45 años, con consumo crónico de alcohol y operado de bypass gástrico hace 1 año, es traído por confusión, marcha atáxica y visión doble de 1 semana. Al examen tiene nistagmo y paresia bilateral del VI par. La glicemia capilar es 65 mg/dL. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Administrar suero glucosado y luego evaluar

B Administrar tiamina endovenosa antes o junto con la glucosa

C Solicitar RM de encéfalo y esperar el resultado

D Iniciar vitamina B12 intramuscular

E Indicar haloperidol para la confusión

Respuesta B. Confusión, ataxia y oftalmoplejía en un alcohólico o post cirugía bariátrica es encefalopatía de Wernicke por déficit de tiamina, una urgencia. Se da tiamina endovenosa en dosis altas antes o junto con la glucosa, porque la glucosa sola consume la tiamina residual y puede empeorar el cuadro. El diagnóstico es clínico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 22

Hombre con antecedente de cirugía bariátrica hace 1 año+consumo de OH desde hace 7 meses, deja de asistir a control médico, parte con 1 semana de evolución de ataxia, dificultad de la marcha, visión doble,confusión, somnolencia, cual es la deficiencia:

A Tiamina, Wernicke, llevaba solo un año desde la Cx y la presentación de síntomas era más aguda. Tenia triada de wernicke: encefalopatía, oftalmoplejía y ataxia (COCA como le dice Guevara).

B Vitamina B12

C Vitamina C

D Laparotomía exploratoria

E Cirugía laparoscópica

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Tiamina, Wernicke, llevaba solo un año desde la Cx y la presentación de síntomas era más aguda. Tenia triada de wernicke: encefalopatía, oftalmoplejía y ataxia (COCA como le dice Guevara).).

▶ VER CLASE 1.02.2.005 Hipertrigliceridemia grave

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.5 · Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis

QUÉ HAY QUE SABER

- TG >500–1.000 mg/dL: el riesgo principal es la pancreatitis aguda (más necrotizante); suero lactescente y xantomas eruptivos.
- Causas: diabetes descompensada, alcohol, obesidad, hipotiroidismo, embarazo, fármacos (estrógenos, corticoides, retinoides) sobre una predisposición genética.
- 500–999 riesgo inminente; ≥1.000 crítico: fibrato inmediato (fenofibrato 160–200 mg/día o gemfibrozilo 600 mg c/12 h), cero alcohol y dieta con grasas <15–20 % de las calorías, sin azúcares simples.
- Si hay que asociar estatina, usar fenofibrato; nunca gemfibrozilo + estatina (rabdomiólisis).
- Con pancreatitis: manejo hospitalario de la pancreatitis, insulina EV (baja TG) y eventualmente plasmaféresis; controlar glicemia.
- Seguimiento: derivar a especialista si TG persisten altos o hay pancreatitis.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 47 años, con obesidad, DM2 en tratamiento con metformina y consumo de 5 cervezas diarias. Asintomático. En un control se informa suero lactescente, triglicéridos 1.450 mg/dL, colesterol total 310 mg/dL, HDL 26 mg/dL. Lipasa normal. Examen abdominal sin dolor. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar atorvastatina 80 mg/día

B Solo dieta y control en 6 meses, ya que está asintomático

C Iniciar ezetimibe y controlar en 3 meses

D Iniciar fibrato, suspender completamente el alcohol y dieta muy baja en grasas

E Agregar gemfibrozilo a una estatina en dosis alta

Respuesta D. Triglicéridos sobre 1.000 mg/dL: hipertrigliceridemia grave con alto riesgo de pancreatitis aguda. La prioridad deja de ser el LDL; se inicia de inmediato un fibrato, se suspende totalmente el alcohol y se indica una dieta prácticamente sin grasas, además de optimizar el control glicémico. El gemfibrozilo no se combina con estatinas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 77

Un paciente de 45 años, obeso (con IMC:35) y diabético, en tratamiento con metformina y empaglifozina y con antecedente de consumo de 4 cervezas diarias, acude a chequeo. Trae múltiples exámenes, entre los que destaca perfil lipídico con colesterol LDL: 135 mg/dl, colesterol HDL: 27 mg/dl y triglicéridos: 1.000 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente en este momento?

A Enviar al servicio de urgencias
B Iniciar gemfibrozilo 900 mg/día
C Iniciar rosuvastatina 40 mg/día
D Iniciar ezetimibe 10 mg/día
E Iniciar dieta estricta

Respuesta E. Manejo de Hipertrigliceridemia Severa: En un paciente con dislipidemia mixta el objetivo suele ser bajar el colesterol LDL, a menos que los triglicéridos sean > 500 mg/dL, en que la prioridad es bajar los triglicéridos. Con niveles > 1000 mg/dL, hay alto riesgo de pancreatitis, por lo que se debe manejar urgentemente. Hace años incluso se recomendaba hospitalizarlos para el manejo, sin embargo esa recomendación actualmente está obsoleta (tal vez el Eunacom aún la considera). La medida más...

▶ VER CLASE 1.02.2.006 Hipoglicemias

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 1.5 · Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular
Diabetes 2.2 · Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas
Diabetes 3.2 · Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis
Diabetes 3.4 · Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate

QUÉ HAY QUE SABER

- Niveles: 1 <70 mg/dL; 2 <54 mg/dL; 3 severa = compromiso de conciencia o requiere un tercero. Confirmar con tríada de Whipple.
- Síntomas autonómicos (<70: sudor, temblor, taquicardia, hambre) y neuroglucopénicos (<54: confusión, convulsiones, coma). El propranolol enmascara la alarma, salvo la sudoración.
- Consciente: regla de los 15 (15 g de azúcar, control en 15 min, repetir) y luego colación compleja. Inconsciente con vía: glucosa 30 % 20–50 mL EV + SG 10 %; sin vía: glucagón 1 mg IM/SC (ineficaz en alcohol o desnutrición).
- Por glibenclamida: aunque despierte, hospitalizar 24–48 h con SG 10 % y HGT cada 1–2 h; suspender la sulfonilurea.
- Ajustar el tratamiento: buscar causa (omisión de comida, ejercicio, ERC, exceso de insulina, Somogyi) y relajar metas en adulto mayor.
- No diabético: muestra crítica con glicemia <55 (insulina, péptido C, sulfonilureas). Insulina alta + péptido C bajo = insulina exógena; ambos altos con screening negativo = insulinoma.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 72

Un paciente de 78 años, diabético, en tratamiento con glibenclamida 15 mg/día, presenta convulsiones tónico-clónicas subintrantes desde hace algunos minutos. Hace 3 días se realizó control de exámenes, con glicemia de ayuno de 185 mg/dl y electrolitos plasmáticos dentro de rangos normales. **¿Cuál es la causa más probable de sus convulsiones?**

A Hipomagnesemia
B Hipernatremia
C Hipoglicemia
D Hipocalcemia
E Cetoacidosis

Respuesta C. La glibenclamida tiene alto riesgo de hipoglicemia, sobre todo en el adulto mayor. Una glicemia alta hace 3 días no impide que ahora esté baja: es típico que el paciente mal controlado refuerce por su cuenta la dosis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 40

Un paciente de 67 años, diabético, tipo 2, en tratamiento con metformina 1700 mg/día y glibenclamida 20 mg/día, ambos separados en dos dosis diarias consulta por episodios repetidos de mareos, malestar y sudoración, asociado a temblor, que ocurren al final de la mañana o antes de almuerzo. Han coincidido con glicemias capilares de 65 mg/dl. Su IMC es 32 Kg/m2. Su hemoglobina A1c resulta 8,1. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Suspender la glibenclamida
B Agregar una colación con 25 gramos de hidrato de carbono antes del almuerzo
C Suspender la glibenclamida
D Reemplazar la glibenclamida por sitagliptina
E Reemplazar la metformina por pioglitazona

Respuesta D. Las hipoglicemias son causadas por la glibenclamida, que debe cambiarse por otro hipoglicemiante sin riesgo de hipoglicemia. Como el control metabólico es malo (HbA1c 8,1), no basta con suspenderla ni con agregar una colación.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 119

Un paciente de 60 años, con antecedente de diabetes mellitus 2 insulinodependiente, en tratamiento con insulina NPH 30 U en la mañana y 20 U en la noche, presenta un cuadro de malestar, sudoración y palpitaciones intensas a las 3 de la madrugada, que respondió a la ingesta de azúcar, constatándose un hemoglucotest de 50 mg/dL. Su examen físico no muestra alteraciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Disminuir la insulina NPH matinal
B Modificar los horarios de las insulinas
C Disminuir la insulina NPH nocturna
D Suspender la insulina NPH nocturna
E Disminuir ambas dosis de insulina NPH

Respuesta C. La NPH nocturna es la que actúa a las 3 AM, así que es la responsable de la hipoglicemia. Se reduce esa dosis (10–20 %, 2 a 4 UI); no se suspende ni se tocan ambas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 76 años con DM2 de 15 años de evolución, en tratamiento con glibenclamida 5 mg cada 12 horas y metformina 850 mg/día. Llega en ambulancia por compromiso de conciencia y sudoración profusa. Hemoglucotest: 36 mg/dL. Tras dos ampollas de glucosa al 30% endovenosa recupera la conciencia, con glicemia de 110 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Alta con colación y control en APS
B Alta reduciendo la glibenclamida a la mitad
C Hospitalizar con suero glucosado al 10% por al menos 24 horas y suspender la glibenclamida
D Glucagón intramuscular y alta
E Suspender la metformina y dar el alta

Respuesta C. Hipoglicemia severa por glibenclamida en una adulta mayor: los metabolitos activos se acumulan y la hipoglicemia recurre al terminar el bolo. Se hospitaliza con glucosa al 10% continua por 24 horas y se suspende la glibenclamida en forma definitiva.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 81 años, DM2 en tratamiento con glibenclamida 5 mg cada 12 horas, con enfermedad renal crónica. Su hija la encuentra somnolienta y sudorosa. En el SAPU: sopor, piel fría, hemoglucotest 38 mg/dL. Tras 40 ml de glucosa al 30% EV despierta lúcida a los 10 minutos, con hemoglucotest de 140 mg/dL, y pide volver a su casa. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Alta con colación y suspender la dosis de glibenclamida de la noche
B Observar 2 horas y dar de alta si el hemoglucotest es mayor de 100 mg/dL
C Hospitalizar 24 a 48 horas con suero glucosado al 10% y hemoglucotest seriados
D Administrar glucagón 1 mg IM y enviar a domicilio acompañada
E Alta con la regla de los 15 indicada a la familia

Respuesta C. Hipoglicemia severa por glibenclamida en adulta mayor con falla renal: la vida media prolongada y los metabolitos activos hacen que la hipoglicemia recurra horas después. Aunque despierte, se hospitaliza 24–48 horas con suero glucosado al 10% y controles cada 1–2 horas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 22 años con DM1 presenta temblor, palpitaciones, diaforesis y una glicemia capilar de 58 mg/dL. Se encuentra lúcido, colaborativo y con capacidad para deglutir normalmente. **¿Cuál es el manejo inicial recomendado según la evidencia y guías clínicas?**

A Administrar 1 mg de glucagón intramuscular de inmediato
B Indicar la ingesta de 15 gramos de hidratos de carbono simples por vía oral y reevaluar la glicemia en 15 minutos
C Canalizar una vía venosa periférica e infundir 2 ampollas de glucosa al 30% en bolo
D Indicar el consumo de un sándwich con mantequilla y carne para retardar la absorción
E Indicar reposo absoluto y esperar 1 hora para una nueva medición sin ingerir alimentos

Respuesta B. Paciente consciente con vía oral segura: regla de los 15. Quince gramos de carbohidratos simples por boca, esperar 15 minutos y repetir la glicemia hasta superar 70 mg/dL. El glucagón y la glucosa EV se reservan para el paciente inconsciente.

▶ VER CLASE **1.02.2.007** **Síndrome hiperosmolar no cetósico** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 4.1 · Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)
Diabetes 4.2 · Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH
Diabetes 4.3 · Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato
Diabetes 4.4 · Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea
Diabetes 4.5 · Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome hiperosmolar no cetósico: DM2 de edad avanzada, deshidratación de días con compromiso de conciencia; glicemia >600 mg/dL, osmolaridad efectiva >320, sin acidosis ni cetosis significativa.
- Calcular osmolaridad efectiva 2×Na + glicemia/18 y sodio corregido Na + 1,6×(glicemia – 100)/100.
- Gatillantes: infecciones (n.° 1), IAM, ACV, corticoides, diuréticos, menor acceso al agua en adulto mayor.

- Manejo inicial: SF 0,9 % 1.000–1.500 mL la primera hora (bolos si shock); luego NaCl 0,45 % si Na corregido ≥135. Potasio según niveles. Insulina EV 0,1 UI/kg/h tras hidratar; SG 5 % cuando la glicemia llega a 300.
- Reponer 8–12 L en 24–48 h sin bajar la osmolaridad más de 3 mOsm/kg/h (edema cerebral); profilaxis de trombosis.
- Seguimiento: derivar; requiere hospitalización y luego control endocrinológico.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 78 años con DM2 en tratamiento con metformina, traído por 5 días de poliuria, sed intensa y decaimiento, con escasa ingesta de líquidos. Está somnoliento pero responde, mucosas secas, PA 100/60 mmHg, FC 108 lpm. Glicemia 780 mg/dL, Na 146 mEq/L, nitrógeno ureico 58 mg/dL, pH 7,35, HCO3 21 mEq/L, cetonemia negativa. Osmolaridad efectiva calculada 336 mOsm/L. Potasio 4,6 mEq/L. **¿Cuál es la primera medida terapéutica?**

A Bolo de insulina cristalina endovenosa de 0,1 UI/kg

B Bicarbonato de sodio endovenoso

C Suero glucosado al 5 %

D Solución fisiológica al 0,9 % 1 a 1,5 litros en la primera hora

E Suero hipotónico al 0,45 % en bolo rápido

Respuesta D. Estado hiperglicémico hiperosmolar: glicemia sobre 600 mg/dL, osmolaridad sobre 320 mOsm/L, sin cetosis ni acidosis importante. El déficit de agua es enorme, así que lo primero es solución fisiológica al 0,9 %. La insulina se inicia después de hidratar y con potasio sobre 3,3 mEq/L.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En un paciente cursando un Estado Hiperglicémico Hiperosmolar con glicemia de 900 mg/dL y sodio plasmático medido de 140 mEq/L, tras haber completado la reanimación inicial con 1.500 ml de solución salina al 0.9% en la primera hora. **¿Cuál es el fluido intravenoso de elección para la fase de mantenimiento?**

A Suero Fisiológico al 0.9% (NaCl 0.9%)

B Solución Salina Hipotónica al 0.45% (NaCl 0.45%)

C Suero Glucosado al 10%

D Ringer Lactato con bicarbonato

E Agua destilada endovenosa pura sin electrolitos

Respuesta B. Na corregido = 140 + 1,6 × (900 − 100)/100 = 152,8 mEq/L. Con sodio corregido ≥ 135 hay déficit de agua libre: se usa NaCl 0,45% a 250–500 ml/h. El glucosado se agrega recién cuando la glicemia llega a ≤ 300 en el EHH.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 74 años en tratamiento por estado hiperglicémico hiperosmolar (glicemia de ingreso 840 mg/dL, sin cetosis). Ya recibió la reposición inicial de volumen y está con NaCl 0,45 % e insulina cristalina en infusión endovenosa continua. K 4,2 mEq/L. A las 8 horas la glicemia es de 290 mg/dL, la osmolaridad efectiva 326 mOsm/L y aún está somnoliento. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Agregar suero glucosado al 5 % y reducir la infusión de insulina

B Suspender la insulina hasta que la glicemia vuelva a subir

C Mantener la misma infusión hasta lograr glicemia bajo 150 mg/dL

D Pasar a insulina NPH subcutánea

E Administrar un bolo de insulina para acelerar la corrección

Respuesta A. En el estado hiperosmolar, cuando la glicemia llega a 300 mg/dL se agrega suero glucosado al 5 % y se reduce la insulina a 0,02–0,05 UI/kg/h, manteniendo la glicemia entre 250 y 300 mg/dL hasta que la osmolaridad baje de 315 y el paciente esté lúcido. Así se evita una caída brusca de la osmolaridad.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 76 años con DM2, hospitalizada hace 30 horas por estado hiperglicémico hiperosmolar, con insulina cristalina en infusión endovenosa y suero glucosado. Control actual: glicemia 240 mg/dL, Na 141 mEq/L, osmolaridad efectiva 309 mOsm/L, pH 7,38, K 4,0 mEq/L. Está lúcida, orientada como antes del cuadro, y pide comer. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener la infusión endovenosa hasta lograr glicemia bajo 140 mg/dL

B Administrar insulina basal subcutánea y mantener la infusión endovenosa 1 a 2 horas más antes de suspenderla

C Suspender la bomba y controlar con hemoglucotest sin insulina

D Suspender la bomba y administrar solo insulina cristalina subcutánea según hemoglucotest

E Mantener régimen cero y la infusión por 24 horas más

Respuesta B. El estado hiperosmolar está resuelto: osmolaridad efectiva bajo 315 mOsm/L, glicemia bajo 250–300 mg/dL y paciente lúcida que tolera la vía oral. Se pasa a insulina subcutánea traslapando: se inyecta la basal y la bomba se mantiene 1 a 2 horas, porque la insulina endovenosa dura solo minutos.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 81 años, postrado, con DM2, hospitalizado por estado hiperglicémico hiperosmolar secundario a una neumonía: glicemia 920 mg/dL, osmolaridad efectiva 352 mOsm/L, sin cetosis. Se inicia hidratación con suero fisiológico, insulina en infusión endovenosa y antibióticos. Plaquetas 210.000/mm³, sin sangrado activo ni contraindicaciones. **Además del tratamiento indicado, ¿qué medida corresponde agregar?**

A Bicarbonato de sodio endovenoso

B Fosfato de potasio endovenoso de rutina

C Profilaxis de trombosis venosa con heparina de bajo peso molecular

D Manitol profiláctico

E Restricción de líquidos para evitar edema cerebral

Respuesta C. La deshidratación extrema, la hiperviscosidad y la inmovilidad hacen del estado hiperosmolar un cuadro con alto riesgo trombótico, tanto venoso como arterial. Se indica profilaxis con heparina de bajo peso molecular salvo contraindicación. El bicarbonato no se usa porque no hay acidosis, y el fosfato solo se repone si es menor de 1 mg/dL.

Conocimientos generales

14 códigos

▶ VER CLASE 1.02.3.001

Alimentación saludable

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.6 · Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Dieta saludable: predominio de verduras, frutas (5 porciones/día), legumbres, cereales integrales, pescado 2 veces/semana y lácteos descremados.
- Limitar sal (<5 g/día), azúcares libres (<10 % de las calorías), grasas saturadas y trans; evitar ultraprocesados y bebidas azucaradas. Preferir aceites vegetales y frutos secos.
- Ley de etiquetado chilena (sellos 'ALTO EN' calorías, azúcares, grasas saturadas, sodio): preferir alimentos con menos sellos.
- Guías Alimentarias para Chile: agua 6–8 vasos/día, comer en familia, cocinar en casa.
- Combinar con actividad física: 150 min/semana de intensidad moderada en adultos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 35 años, sana, solicita orientación sobre alimentación saludable para su familia. **Según las Guías Alimentarias para la Población Chilena, ¿cuál de las siguientes recomendaciones es correcta?**

A Preferir jugos de fruta azucarados a la fruta entera

B Consumir pescado solo una vez al mes

C Consumir legumbres al menos 2 veces por semana

D Consumir 1 porción de frutas y verduras al día

E Evitar completamente los lácteos en adultos

Respuesta C. Las Guías Alimentarias chilenas recomiendan legumbres y pescado al menos 2 veces por semana, 5 porciones diarias de frutas y verduras de distintos colores, 3 porciones de lácteos bajos en grasa y azúcar, 6 a 8 vasos de agua y evitar alimentos con sellos 'ALTO EN'. La fruta entera se prefiere a los jugos.

▶ VER CLASE 1.02.3.002

Anorexia nerviosa

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.6 · Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Criterios: restricción de la ingesta con peso significativamente bajo, miedo intenso a ganar peso y alteración de la imagen corporal. Subtipos restrictivo y con atracones/purgas.
- Típica en mujer adolescente; gravedad por IMC (leve ≥17, moderada 16–16,99, grave 15–15,99, extrema <15).
- Complicaciones: bradicardia, hipotensión, hipotermia, arritmias (QT largo), amenorrea hipotalámica, osteoporosis, lanugo, hipokalemia y alcalosis si purga.
- Hospitalizar ante inestabilidad (FC <40–50, hipotensión, alteraciones electrolíticas), IMC muy bajo o riesgo suicida; realimentación gradual por síndrome de realimentación (hipofosfemia).
- Tratamiento multidisciplinario: rehabilitación nutricional, psicoterapia (terapia familiar en adolescentes); los fármacos tienen rol menor. Derivar a psiquiatría.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 4

Una paciente de 25 años, con antecedente de anorexia nerviosa desde hace 5 años, actualmente pesa 29 kg y mide 1,68 m, con IMC de 10,3 kg/m². **¿Con cuántas kilocalorías diarias se debe iniciar su alimentación?**

A 300
B 600
C 1200
D 1500
E 2400

Respuesta A. Con desnutrición extrema (IMC bajo 12) el riesgo de síndrome de realimentación es muy alto: hipofosfemia, hipokalemia, hipomagnesemia, insuficiencia cardíaca y arritmias. Se inicia con un aporte bajo, alrededor de 10 kcal/kg/día (unas 300 kcal en 29 kg), con tiamina y control de electrolitos, y se aumenta progresivamente.

▶ VER CLASE 1.02.3.003 Diabetes y riesgo cardiovascular

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 1.5 · Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular
Diabetes 2.3 · Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4

QUÉ HAY QUE SABER

- La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el diabético; la DM con más de 10 años o con daño de órgano blanco es de riesgo alto o muy alto.
- El control glicémico protege sobre todo la microvasculatura; lo que más reduce eventos macrovasculares es controlar PA (<130/80), LDL (<70, o <55 si muy alto riesgo) y suspender el tabaco.
- Control glicémico agresivo (HbA1c <6 %, ACCORD) aumenta la mortalidad por hipoglicemias: metas individualizadas.
- Fármacos con beneficio cardiovascular: metformina (UKPDS), agonistas GLP-1 (liraglutida, semaglutida) en enfermedad aterosclerótica e iSGLT2 en insuficiencia cardíaca y ERC.
- Estatina en la mayoría de los diabéticos adultos; AAS en prevención secundaria. Ejercicio 150 min/semana.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 52 años con DM2 de 2 años de evolución, en tratamiento con metformina, HbA1c 6,9 %. No fuma. Presión arterial 128/80 mmHg. Sin antecedentes de infarto ni ACV. Perfil lipídico: colesterol total 196 mg/dL, LDL 112 mg/dL, HDL 44 mg/dL, triglicéridos 180 mg/dL. Creatinina normal. **Según el Programa de Salud Cardiovascular del MINSAL, ¿cuál es la conducta más adecuada respecto a su riesgo cardiovascular?**

A No requiere estatina, porque su LDL es menor de 130 mg/dL
B Calcular el riesgo con tablas y repetir perfil lipídico en un año
C Iniciar gemfibrozilo por la hipertrigliceridemia
D Iniciar aspirina 100 mg/día como prevención primaria
E Iniciar atorvastatina, porque la diabetes lo clasifica como alto riesgo cardiovascular

Respuesta E. En el Programa de Salud Cardiovascular, la persona con diabetes mayor de 40 años se clasifica directamente como alto riesgo cardiovascular, sin necesidad de tablas, y se le indica estatina independiente del LDL. La aspirina no se indica de rutina en prevención primaria.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 64 años con DM2 en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de 32%, con disnea de esfuerzo CF II. HbA1c 8,2%. VFG 62 mL/min. Se decide asociar un segundo fármaco. **¿Cuál es el segundo fármaco de elección?**

A Glibenclamida
B Pioglitazona
C Empagliflozina o dapagliflozina
D Sitagliptina
E Insulina NPH nocturna

Respuesta C. DM2 con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida: el segundo fármaco de elección es un iSGLT2, que reduce en más de 30% las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y frena el deterioro renal, sin hipoglicemias. La pioglitazona retiene líquido y está contraindicada.

▶ VER CLASE 1.02.3.004 Estilos de vida saludables (hábitos y conductas)

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 1.5 · Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular

QUÉ HAY QUE SABER

- Pilares: alimentación saludable, actividad física regular, no fumar, consumo de alcohol bajo riesgo, sueño adecuado y manejo del estrés.
- Actividad física: 150 min/semana aeróbica moderada (caminar rápido, nadar, bicicleta) en al menos 3 días, sin más de 2 días seguidos de inactividad, y fuerza 2–3 veces/semana.
- El ejercicio aumenta la captación de glucosa por GLUT-4 sin insulina; baja HbA1c 0,5–1 % y la sensibilidad dura 24–48 h.

- En usuarios de insulina o glibenclamida: glicemia <100 antes del ejercicio requiere colación de 15–20 g; >250 con cetonas, no hacer ejercicio. Neuropatía: natación o bicicleta; retinopatía proliferativa: evitar Valsalva.
- Consejería breve en cada control (modelo de etapas de cambio); programas chilenos como Elige Vivir Sano y Vida Sana.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 54 años con DM2 en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas e insulina NPH 18 UI matinal. Decide iniciar un programa de acondicionamiento físico. Antes de salir a trotar a las 11:00 se realiza un hemoglucotest de 88 mg/dL. No tiene síntomas neurológicos ni sudoración. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Suspender el ejercicio por hipoglicemia

B Ingerir una colación de 15 a 20 g de carbohidratos antes de comenzar

C Salir a trotar de inmediato, ya que está asintomático

D Suspender la insulina NPH desde mañana

E Administrar insulina cristalina antes de iniciar

Respuesta B. Usa insulina NPH, cuyo peak matinal ocurre 4 a 6 horas después de la dosis, justo a la hora del ejercicio. Con glicemia < 100 mg/dL antes del esfuerzo, debe comer 15 a 20 g de carbohidratos y luego hacer ejercicio. 88 mg/dL no es una hipoglicemia que obligue a suspender.

▶ VER CLASE 1.02.3.005 Prevención de complicaciones crónicas de la diabetes

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 1.4 · Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas

QUÉ HAY QUE SABER

- Control metabólico individualizado: HbA1c <7 % previene complicaciones microvasculares; PA <130/80 y LDL <70 previenen las macrovasculares.
- Tamizaje anual desde el diagnóstico en DM2 (DM1 desde los 5 años): RAC en orina matinal y creatinina, fondo de ojo o retinografía, examen de pies con monofilamento.
- Albuminuria confirmada: IECA o ARA-II aunque sea normotenso, + iSGLT2. Retinopatía: derivar a oftalmología.
- Pie: educación, calzado adecuado, inspección diaria, podología; clasificar riesgo con monofilamento y pulsos.
- Suspender tabaco, estatina según riesgo, vacunación (influenza, neumococo) y evitar nefrotóxicos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años con DM2 de 6 años de evolución, en tratamiento con metformina, HbA1c 7,2 %. Presión arterial 126/78 mmHg. En su control anual se detecta una razón albúmina/creatinina urinaria de 85 mg/g, que se confirma en una segunda muestra 2 meses después. Creatinina 0,9 mg/dL, VFG 88 mL/min. **¿Cuál es la conducta más adecuada para prevenir la progresión de la nefropatía?**

A Cambiar la metformina por glibenclamida

B Restringir las proteínas a 0,4 g/kg/día

C Iniciar enalapril o losartán

D Controlar la albuminuria en un año, ya que la presión es normal

E Agregar amlodipino

Respuesta C. Albuminuria moderadamente elevada confirmada (30–300 mg/g) en diabético: se indica IECA o ARA II aunque la presión sea normal, porque reducen la albuminuria y retrasan la nefropatía. La restricción proteica extrema no se recomienda y el amlodipino no tiene efecto antiproteinúrico.

▶ VER CLASE 1.02.3.006 Prevención de Diabetes Mellitus tipo 2

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.6 · Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizar con glicemia de ayuno a quien tenga IMC ≥25 + 1 factor de riesgo o ≥45 años; normal (<100) repetir cada 3 años.
- Prediabetes: glicemia de ayuno 100–125, PTGO 2 h 140–199 o HbA1c 5,7–6,4 %. Ayuno 100–125 se estudia con PTGO.
- Intervención más eficaz: estilo de vida, con baja de 5–7 % del peso y 150 min/semana de actividad física (reduce cerca de 58 % la progresión, DPP).
- Metformina como segunda línea en alto riesgo (ITG con IMC >35, menores de 60 años, DMG previa).
- Grupos de riesgo: antecedente familiar, DMG previa, SOP, síndrome metabólico, acantosis nigricans. Mujer con DMG: PTGO posparto.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 30

Hombre de 48 años con glicemia de ayuno de 115 mg/dL en dos ocasiones. IMC 28. Sin otros factores de riesgo. **¿Cuál es la intervención más importante para reducir la progresión a diabetes?**

A Dieta estricta baja en carbohidratos

B Metformina 500 mg dos veces al día

C Ejercicio aeróbico 150 minutos por semana

D Orlistat

E Insulina basal

Respuesta C. Glicemia de ayuno entre 100 y 125 mg/dL: prediabetes. La intervención más efectiva para frenar la progresión a diabetes es el cambio de estilo de vida, con ejercicio aeróbico de intensidad moderada de al menos 150 minutos por semana, más dieta saludable.

▶ VER CLASE 1.02.3.007 Prevención de dislipidemias

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.4 · Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizaje con perfil lipídico en el examen de medicina preventiva y en el PSCV; antes en antecedente familiar de hipercolesterolemia o enfermedad coronaria precoz.
- Estimar riesgo cardiovascular global para definir la meta de LDL e indicar estatina.
- Dieta: reducir grasas saturadas (<7–10 % de las calorías) y eliminar grasas trans; aumentar fibra soluble, pescado y aceites vegetales; limitar azúcares simples y alcohol (bajan TG).
- Actividad física regular, mantener peso saludable y no fumar (sube HDL).
- Hipercolesterolemia familiar (LDL ≥190): tamizaje en cascada de familiares de primer grado.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 42 años, con colesterol LDL de 145 mg/dL, sin otros factores de riesgo y con riesgo cardiovascular bajo, pregunta qué cambio alimentario reduce más su LDL. **¿Cuál es la medida dietética más efectiva para reducir el colesterol LDL?**

A Suprimir todas las grasas, incluidos el aceite de oliva y los frutos secos

B Eliminar completamente los huevos

C Aumentar el consumo de azúcares simples

D Consumir más carnes rojas procesadas

E Reducir las grasas saturadas y trans, reemplazándolas por grasas insaturadas

Respuesta E. Las grasas saturadas (carnes grasas, mantequilla, embutidos) y trans son los principales determinantes dietéticos del LDL. Reemplazarlas por grasas insaturadas (aceite de oliva o canola, frutos secos, pescado), sumando fibra soluble y actividad física, es la base de la prevención. El colesterol del huevo influye menos.

▶ VER CLASE 1.02.3.008 Prevención de la obesidad

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.1 · Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- En niños: menor de 5 años usar Peso/Talla y de 5 a 19 años IMC/Edad; sobrepeso +1 a +2 DE, obesidad >+2 DE, obesidad severa ≥+3 DE.
- Prevención desde la gestación y la infancia: lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, alimentación complementaria sin azúcar añadida, evitar jugos y bebidas azucaradas.
- Sobrepeso u obesidad infantil: sin dietas restrictivas (nunca bajo 2 años); eliminar azúcar y ultraprocesados y aumentar el juego activo diario; la meta es que la talla alcance al peso.
- Limitar pantallas, promover actividad física diaria (60 min en niños) y sueño adecuado.
- Políticas chilenas: Ley de etiquetado (sellos), programa Elige Vivir Sano, Vida Sana; controles de salud con antropometría seriada.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En el control de salud de un niño de 4 años, el IMC está en percentil 80 (normal). Los padres refieren que toma bebidas azucaradas a diario y ve pantallas 4 horas al día. **¿Cuál es la intervención preventiva más adecuada?**

A Indicar una dieta hipocalórica estricta

B Consejería familiar: reemplazar bebidas azucaradas por agua, limitar pantallas a 1 hora diaria y promover juego activo diario

C Iniciar metformina

D Derivar a cirugía

E No intervenir, porque aún no tiene sobrepeso

Respuesta B. La prevención de la obesidad infantil se basa en cambiar hábitos de toda la familia: agua en vez de bebidas azucaradas, frutas y verduras, comidas en familia, al menos 60 minutos diarios de actividad física y limitar pantallas (máximo 1 hora en preescolares). Esperar el sobrepeso pierde la oportunidad preventiva; las dietas restrictivas no se indican en niños.

▶ VER CLASE 1.02.3.009 Prevención de pié diabético

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.3 · Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen anual de pies en el PSCV: monofilamento 10 g (un punto no percibido = alto riesgo), diapasón 128 Hz, pulsos pedio y tibial posterior; si faltan, índice tobillo-brazo.
- Clasificar el riesgo de ulceración y ajustar la frecuencia de control según el riesgo.
- Educación: inspección diaria de los pies (espejo), lavado y secado entre los dedos, hidratación sin crema interdigital, corte recto de uñas, no caminar descalzo ni usar guateros.
- Calzado acolchado sin costuras internas, podología para callosidades y uñas; plantillas de descarga en deformidades.
- Control de glicemia, PA y lípidos, suspender tabaco; consultar precozmente ante cualquier lesión.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En el control de una mujer de 60 años con DM2 de 12 años de evolución, el examen con monofilamento de 10 g muestra pérdida de sensibilidad en ambos pies. No tiene úlceras ni deformidades y los pulsos son normales. **¿Cuál es la medida preventiva más adecuada?**

A Indicar caminar descalza para fortalecer los pies

B Educación en autocuidado con inspección diaria de los pies, calzado adecuado y control podológico periódico

C Remojar los pies en agua caliente diariamente

D Amputación profiláctica de ortejos

E Controlar los pies solo si aparece una úlcera

Respuesta B. La pérdida de sensibilidad protectora al monofilamento aumenta el riesgo de ulceración. Se indica educación (inspección diaria, secado entre ortejos, no andar descalza, no remojar en agua caliente), calzado adecuado, podología y controles periódicos. Todo diabético debe tener evaluación de riesgo de pie al menos una vez al año.

▶ VER CLASE 1.02.3.010 Regímenes dietéticos fundamentales

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.3 · Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Régimen común (normal): balanceado, 50–60 % carbohidratos, 15–20 % proteínas y 25–30 % grasas; base para los demás.
- Por consistencia: líquido (claro o completo), papilla, blando y liviano; se progresa según tolerancia (postoperatorio, disfagia, adulto mayor).
- Hiposódico (<2 g de sodio en HTA, IC, cirrosis con ascitis), hipograso (colelitiasis, pancreatitis), sin residuo (preparación de colonoscopia, diarrea aguda) y rico en fibra (constipación, diverticulosis).
- Diabético: fraccionado, carbohidratos complejos de bajo índice glicémico, sin azúcares simples. Renal: control de proteínas, potasio, fósforo y sodio según etapa.
- Sin gluten de por vida en enfermedad celíaca; sin lactosa en intolerancia. En la cirrosis no se restringen las proteínas (1,2–1,5 g/kg/día) salvo encefalopatía refractaria.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 58 años con cirrosis hepática por alcohol presenta ascitis moderada, sin encefalopatía. Su natremia es 136 mEq/L. **¿Cuál es el régimen dietético más adecuado?**

A Restricción hídrica bajo 500 mL/día

B Restricción proteica estricta, bajo 0,5 g/kg/día

C Régimen hiposódico (unos 2 g de sodio al día) con aporte proteico normal

D Régimen hipersódico para expandir el volumen

E Ayuno hasta resolver la ascitis

Respuesta C. En la ascitis cirrótica el pilar dietético es la restricción de sodio (unos 2 g de sodio, o 5 g de sal, al día) junto a diuréticos. El aporte proteico debe ser normal (1,2-1,5 g/kg/día), porque suelen estar desnutridos; la restricción proteica ya no se recomienda. La restricción hídrica solo se indica con natremia bajo 125 mEq/L.

▶ VER CLASE 1.02.3.011 Regímenes dietéticos para dislipidemias

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.5 · Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipercolesterolemia: reducir grasas saturadas (<7 % de las calorías) y eliminar grasas trans; colesterol dietario bajo; preferir aceites vegetales, pescado, legumbres y fibra soluble (avena).
- Hipertrigliceridemia: eliminar alcohol y azúcares simples/fructosa, reducir carbohidratos refinados y bajar de peso.
- TG ≥500–1.000 mg/dL: dieta casi sin grasa (<15–20 % de las calorías), cero alcohol y sin azúcares simples, además de fibrato.
- Dieta mediterránea y ejercicio aeróbico regular complementan; omega-3 de pescado ayuda a bajar TG.
- La dieta sola rara vez alcanza la meta de LDL en riesgo alto; no retrasa el inicio de estatina cuando está indicada.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 46 años, obeso, consume 4 a 5 latas de cerveza diarias y bebidas azucaradas. Su perfil lipídico muestra triglicéridos de 650 mg/dL y LDL de 110 mg/dL. No tiene antecedente de pancreatitis. **Además del tratamiento farmacológico, ¿cuál es la medida dietética más importante?**

A Aumentar el consumo de pan blanco

B Aumentar el consumo de jugos de fruta

C Dieta rica en grasas saturadas y baja en proteínas

D Eliminar exclusivamente el huevo

E Suspender el alcohol y reducir azúcares simples y carbohidratos refinados

Respuesta E. La hipertrigliceridemia responde especialmente a suprimir el alcohol, reducir azúcares simples (bebidas, jugos, dulces) y carbohidratos refinados, bajar de peso y hacer ejercicio. Con triglicéridos sobre 500 mg/dL se agrega fibrato por riesgo de pancreatitis, y sobre 1.000 mg/dL, restricción estricta de grasas. El huevo influye poco.

▶ VER CLASE 1.02.3.012 Regímenes dietéticos para obesidad

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.6 · Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Base: déficit de 500–1.000 kcal/día para bajar 0,5–1 kg/semana; meta inicial 5–10 % del peso en 6 meses.
- Distribución balanceada (dieta mediterránea o hipocalórica equilibrada); restringir azúcares simples, bebidas azucaradas, alcohol y ultraprocesados.
- Dietas muy bajas en calorías (<800 kcal) solo bajo supervisión médica; las dietas de moda no son superiores a largo plazo.
- Combinar con 150–300 min/semana de actividad física y terapia conductual para mantener la baja de peso.
- En diabéticos con insulina o sulfonilureas ajustar dosis al reducir la ingesta (riesgo de hipoglicemia).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 45 años, con IMC de 32 kg/m², desea bajar de peso. Su gasto energético estimado es de 2.000 kcal/día. **¿Cuál es la prescripción dietética más adecuada para iniciar?**

A Dieta de 600 kcal/día sin supervisión

B Ayuno total por 2 semanas

C Dieta libre de carbohidratos en forma indefinida

D Dieta con déficit de 500 a 750 kcal/día respecto de su gasto, balanceada y sostenible

E Mantener la ingesta y agregar diuréticos

Respuesta D. Un déficit de 500 a 750 kcal/día (unas 1.200-1.500 kcal en mujeres) produce una baja de 0,5 a 1 kg por semana. La meta inicial es bajar 5 a 10% del peso en 6 meses, lo que ya mejora presión, glicemia y lípidos. Lo clave es la adherencia; las dietas de muy bajo aporte requieren supervisión estricta.

▶ VER CLASE **1.02.3.013** **Riesgo cardiovascular global**

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.4 · Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

QUÉ HAY QUE SABER

- Riesgo cardiovascular global: probabilidad de evento a 10 años según varios factores (edad, sexo, PA, colesterol, tabaco, diabetes); en Chile se usa la tabla de Framingham adaptada.
- Riesgo muy alto sin calcular: evento ateroesclerótico previo (IAM, ACV, AIT, arteriopatía periférica), DM con daño de órgano blanco o VFG <45.
- Alto: DM >10 años sin daño, HTA ≥160/100, ERC 3a o Framingham 10–19 %; moderado: DM <10 años o Framingham 5–9 %; bajo: <5 %.
- El riesgo define la meta de LDL (<55–70 muy alto, <70 alto, <100 moderado) y la intensidad de la estatina.
- Se evalúa en el EMPA y el PSCV; manejar todos los factores juntos, no un número aislado.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 46 años, no fumadora, sin diabetes, consulta en el CESFAM para ingresar al Programa de Salud Cardiovascular. En 3 controles distintos tiene presión arterial promedio de 166/104 mmHg. Perfil lipídico: colesterol total 205 mg/dL, HDL 52 mg/dL, LDL 128 mg/dL. Creatinina 0,7 mg/dL, sin albuminuria. **Según el MINSAL, ¿cómo se clasifica su riesgo cardiovascular?**

A Bajo, porque es mujer menor de 50 años y no fuma

B Moderado, según las tablas de Framingham adaptadas a Chile

C No se puede clasificar sin una prueba de esfuerzo

D Alto, directamente, sin necesidad de usar tablas, por presión arterial de 160/100 mmHg o más

E Alto solo si el LDL supera 190 mg/dL

Respuesta D. En el Programa de Salud Cardiovascular algunas condiciones clasifican directamente como alto riesgo, sin tablas: enfermedad cardiovascular previa, diabetes, ERC etapa 3b o más, LDL 190 mg/dL o más y presión arterial persistente de 160/100 mmHg o más. En los demás se usa la tabla de Framingham adaptada a Chile.

▶ VER CLASE **1.02.3.014** **Síndrome metabólico**

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.6 · Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Conjunto de factores de riesgo ligados a resistencia a la insulina y obesidad abdominal; 3 de 5: cintura aumentada, PA ≥130/85, glicemia ≥100, TG ≥150, HDL bajo.
- Duplica el riesgo cardiovascular y aumenta mucho el riesgo de DM2.
- Prevención: alimentación saludable, actividad física 150 min/semana y mantener peso y cintura normales.
- Detección en el EMPA midiendo cintura, PA, glicemia y perfil lipídico; acantosis nigricans y acrocordones son pistas clínicas.
- El cambio de estilo de vida es el tratamiento de primera línea; tratar cada componente fuera de meta.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 50 años tiene diagnóstico de síndrome metabólico: cintura de 104 cm, triglicéridos 180 mg/dL, HDL 38 mg/dL y glicemia de ayuno 110 mg/dL. Su presión arterial es 128/82 mmHg. **¿Cuál es la intervención de primera línea?**

A Metformina, fenofibrato y losartán desde el inicio

B Cambios de estilo de vida, con meta de bajar 5 a 10% del peso, dieta saludable y actividad física

C Cirugía bariátrica

D Insulina NPH nocturna

E Control anual sin intervención

Respuesta B. El tratamiento de primera línea del síndrome metabólico es el cambio de estilo de vida: bajar 5 a 10% del peso, dieta saludable, al menos 150 minutos semanales de actividad física y no fumar. Esto mejora todos sus componentes a la vez. Los fármacos se agregan según cada componente que lo requiera, no por el diagnóstico.

Exámenes e imagenología

25 códigos

▶ VER CLASE **1.02.4.001** **Arteriografia extremidades inferiores** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.3 · Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Estándar anatómico de la enfermedad arterial periférica: muestra sitio, extensión de estenosis/oclusiones y lecho distal; se pide para planificar revascularización.
- Indicación: isquemia crítica (dolor de reposo, úlcera, gangrena), claudicación invalidante o isquemia aguda, generalmente tras eco-Doppler; la angio-TAC o angio-RM son alternativas menos invasivas.

- En el diabético el compromiso típico es infrapoplíteo (tibiales y peronea), con calcificación difusa.
- Riesgos: nefropatía por contraste (frecuente en diabéticos con ERC), hematoma o pseudoaneurisma en el sitio de punción, alergia al contraste.
- Antes del examen: hidratar, suspender metformina 48 h y controlar creatinina; el médico general emplea el informe para derivar a cirugía vascular.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 70 años, diabético, presenta dolor en reposo en el pie derecho que lo despierta en la noche y una úlcera en el primer ortejo que no cicatriza hace 6 semanas. No tiene pulsos poplíteo ni pedio derechos y el índice tobillo-brazo es 0,3. **¿Cuál es el examen más adecuado para planificar el tratamiento?**

A Arteriografía (o angioTAC) de extremidades inferiores

B Radiografía de pie

C Electromiografía

D Cintigrama óseo

E Repetir el índice tobillo-brazo en 6 meses

Respuesta A. Dolor de reposo y úlcera que no cicatriza con ITB muy bajo es isquemia crítica de la extremidad, con alto riesgo de amputación. Requiere estudio anatómico arterial (arteriografía o angioTAC) para planificar la revascularización endovascular o quirúrgica; la arteriografía además puede ser terapéutica (angioplastía). Esperar implica perder la extremidad.

▶ VER CLASE 1.02.4.002 Ecotomografia abdominal

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.2 · Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen de primera línea, barato y sin radiación, para hígado, vía biliar, páncreas, bazo, riñones y aorta abdominal.
- Hígado graso: hígado hiperecogénico ('brillante'); cirrosis: bordes nodulares, hipertrofia del lóbulo caudado, esplenomegalia, ascitis.
- Vía biliar: de elección en colelitiasis (imagen hiperecogénica con sombra acústica) y para medir dilatación de la vía biliar (colédoco >6 mm).
- Útil en tamizaje semestral de hepatocarcinoma en cirróticos y para caracterizar masas hepáticas iniciales.
- Limitaciones: obesidad y gas intestinal; páncreas a menudo mal visualizado (TAC si sospecha tumor o complicación).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 48 años, con IMC de 33 kg/m², DM2 y triglicéridos elevados, tiene transaminasas 1,5 veces sobre lo normal en un control. No consume alcohol y las serologías de hepatitis B y C son negativas. **¿Cuál es el examen de imagen inicial más adecuado?**

A Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

B Colangiorresonancia

C TAC de abdomen con contraste

D Biopsia hepática de entrada

E Ecotomografía abdominal

Respuesta E. Se sospecha enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica. La ecotomografía abdominal es el examen inicial: barata, sin radiación, muestra el hígado hiperecogénico (esteatosis) y descarta otras causas. Luego se estima fibrosis con FIB-4 o elastografía. La biopsia se reserva para casos dudosos o sospecha de fibrosis avanzada.

▶ VER CLASE 1.02.4.003 Albúmina plasmática

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.14 · Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios

QUÉ HAY QUE SABER

- Valor normal 3,5–5 g/dL; vida media de ~20 días, refleja estado nutricional y síntesis hepática de semanas.
- Hipoalbuminemia: desnutrición crónica, cirrosis (síntesis), síndrome nefrótico (<3 g/dL con proteinuria >3,5 g/24 h), enteropatía perdedora de proteínas, inflamación aguda (reactante de fase negativo).
- Es parte del Child-Pugh y predictor de mortalidad y complicaciones postoperatorias; <3 g/dL indica riesgo nutricional.
- En inflamación aguda baja aunque no haya desnutrición: interpretar con la clínica y la PCR; la prealbúmina refleja cambios recientes (vida media 2 días).
- Corrección del calcio: Ca corregido = Ca medido + 0,8 × (4 − albúmina).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 68 años será operado de una colectomía electiva. Ha bajado 10% de su peso en 3 meses. En el preoperatorio, su albúmina plasmática es 2,6 g/dL, sin proteinuria ni daño hepático. **¿Cuál es la interpretación y la conducta más adecuada?**

A La albúmina es normal y se opera sin cambios

B La albúmina refleja cambios nutricionales en 24 horas

C La albúmina baja indica deshidratación y basta con hidratar

D Es un marcador de desnutrición y de mayor riesgo de complicaciones: optimizar el estado nutricional antes de la cirugía

E Indicar infusión de albúmina como tratamiento nutricional

Respuesta D. La hipoalbuminemia sin pérdidas renales ni daño hepático, junto a baja de peso, indica desnutrición y se asocia a más dehiscencias, infecciones y mortalidad postoperatoria. Se recomienda soporte nutricional por 7 a 14 días antes de una cirugía electiva. La albúmina tiene vida media de unos 20 días y su infusión no nutre.

▶ VER CLASE 1.02.4.004 Relación albuminuria / creatininuria

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.1 · Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen de elección para tamizar nefropatía diabética: en muestra aislada de primera orina matinal, expresado en mg/g.
- Categorías KDIGO: A1 <30 mg/g normal; A2 30–299 (antigua microalbuminuria); A3 ≥300 mg/g.
- Confirmar con 2 de 3 muestras alteradas en 3–6 meses; falsos positivos por ITU, fiebre, ejercicio intenso, hematuria, IC descompensada o hiperglicemia marcada.
- Tamizaje anual: DM2 desde el diagnóstico, DM1 a los 5 años del debut, y en hipertensos.
- RAC ≥30 confirmada: IECA o ARA-II aunque sea normotenso, + iSGLT2; A3: dosis máxima y derivar a nefrología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 61 años con DM2 de 9 años de evolución, PA 126/78 mmHg, sin albuminuria en controles previos. En su control anual se solicita razón albúmina/creatinina urinaria (RAC) en orina matinal: 140 mg/g. Ese día refiere disuria, polaquiuria y fiebre de 38,2 °C desde hace 2 días; el sedimento urinario muestra abundantes leucocitos y bacterias. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a la RAC?**

A Iniciar losartán por albuminuria moderadamente elevada

B Derivar a nefrología por nefropatía diabética

C Solicitar orina de 24 horas para proteinuria

D Tratar la infección urinaria y repetir la RAC una vez resuelta

E Suspender la metformina por daño renal

Respuesta D. La RAC en orina matinal aislada es el examen de tamizaje de la nefropatía diabética, pero se eleva transitoriamente con infección urinaria, fiebre, ejercicio intenso, hiperglicemia marcada o insuficiencia cardíaca descompensada. Se trata la infección y se repite la RAC; solo 2 de 3 muestras alteradas confirman albuminuria.

▶ VER CLASE 1.02.4.005 Creatininemia

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.1 · Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Marcador de filtración glomerular; depende de la masa muscular (baja en adulto mayor, mujeres y desnutridos, puede ocultar ERC).
- Siempre estimar VFG con fórmula (CKD-EPI); ERC si VFG <60 mL/min/1,73 m² por más de 3 meses, etapificar G1–G5.
- Aumento agudo: injuria renal aguda (alza ≥0,3 mg/dL en 48 h o ≥1,5 veces la basal); diferenciar prerrenal, renal y posrenal.
- Guía el ajuste de fármacos: metformina (máx. 1.000 mg si VFG 30–44, suspender <30), antibióticos, contraste yodado.
- Al iniciar IECA/ARA-II se acepta alza de creatinina de hasta 30 %; mayor obliga a buscar estenosis renal o hipovolemia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 84 años, de 45 kg y con sarcopenia, tiene creatinina plasmática de 1,0 mg/dL. Se calcula su velocidad de filtración glomerular estimada (VFGe) en 50 mL/min/1,73 m². **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Tiene disminución de la función renal, que la creatinina sola subestima por su baja masa muscular

B Su función renal es normal, porque la creatinina está en rango normal

C La creatinina sobreestima el daño renal en los adultos mayores

D Debe medirse solo la creatinina en orina de 24 horas

E La VFGe no es aplicable en mayores de 70 años

Respuesta A. La creatinina depende de la masa muscular: en adultos mayores con poca masa muscular, una creatinina normal puede ocultar una VFG disminuida. Por eso se usa la VFG estimada (CKD-EPI), que ajusta por edad y sexo. Es clave para ajustar dosis de fármacos y para etapificar la enfermedad renal crónica.

▶ VER CLASE 1.02.4.006 Cuerpos cetónicos en orina (semicuantitativo)

NIVEL REALIZA, INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 4.1 · Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)

QUÉ HAY QUE SABER

- Tira reactiva que detecta acetoacetato (no el β-hidroxibutirato, el cetoácido predominante en la CAD), por lo que puede subestimar la cetosis.
- Indicación: DM1 con glicemia >250 mg/dL, enfermedad intercurrente, vómitos o dolor abdominal; antes del ejercicio si glicemia >250.
- Interpretación: negativa o trazas tranquiliza; ++ o más con hiperglicemia obliga a descartar cetoacidosis con gases y electrolitos.
- Falsos positivos por ayuno prolongado, embarazo o dieta cetogénica; en la recuperación de la CAD puede seguir positiva aunque el paciente mejore (no sirve para seguir la resolución).
- Técnica: orina fresca, tira no vencida, leer al tiempo indicado por el fabricante.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 25 años con DM1 ingresa con vómitos, dolor abdominal y respiración de Kussmaul. Glicemia 480 mg/dL, pH 7,10, bicarbonato 8 mEq/L y anión gap de 24. La cetonuria con tira reactiva (nitroprusiato) es solo débilmente positiva (+). **¿Cuál es la explicación más probable de la cetonuria débil?**

A Descarta una cetoacidosis diabética

B Indica un estado hiperosmolar puro

C La tira detecta acetoacetato y acetona, pero no el beta-hidroxibutirato, que predomina en la cetoacidosis

D Se debe a que la glicemia es muy alta

E Indica exclusivamente acidosis láctica

Respuesta C. El nitroprusiato detecta acetoacetato y acetona, no beta-hidroxibutirato, que predomina en la cetoacidosis grave. Por eso la cetonuria puede subestimar la cetosis y se prefiere medir beta-hidroxibutirato en sangre. Con acidosis metabólica de anión gap alto e hiperglicemia, el diagnóstico de cetoacidosis se mantiene.

▶ VER CLASE 1.02.4.007 Cuerpos cetónicos en sangre

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 4.1 · Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)

QUÉ HAY QUE SABER

- Mide β-hidroxibutirato capilar o plasmático, el cuerpo cetónico predominante en la cetoacidosis; más exacto que la cetonuria.
- Valores: <0,6 mmol/L normal; 0,6–1,5 cetosis leve; 1,5–3 riesgo de CAD; >3 mmol/L compatible con CAD junto a acidosis.
- Útil para diagnosticar CAD euglicémica en usuarios de iSGLT2 (glicemia <250 con acidosis y gap alto).
- Seguimiento de la resolución: cetonemia <0,6 mmol/L o en franco descenso, junto con pH, bicarbonato y anion gap.
- En hiperglicemia grave sin cetonemia significativa pensar en estado hiperosmolar.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 54 años, DM2 en tratamiento con metformina y dapagliflozina, cursa el segundo día postoperatorio de una colectomía, en ayuno. Presenta náuseas, vómitos, dolor abdominal y polipnea. Hemoglucotest 176 mg/dL. Gases venosos: pH 7,18, HCO_3 11 mEq/L. Na 139, Cl 102 mEq/L. Cetonemia 4,5 mmol/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Acidosis láctica por metformina

B Cetoacidosis diabética euglicémica asociada a iSGLT2

C Estado hiperglicémico hiperosmolar

D Íleo postoperatorio con deshidratación

E Acidosis metabólica hiperclorémica por suero fisiológico

Respuesta B. Acidosis metabólica con anion gap elevado (139 − [102 + 11] = 26) y cetonemia > 3 mmol/L, con glicemia < 200 mg/dL, en una usuaria de dapagliflozina con ayuno y cirugía: cetoacidosis euglicémica. La glicemia normal no descarta la cetoacidosis.

▶ VER CLASE 1.02.4.008 Doppler vascular periférico

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.3 · Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen no invasivo de elección inicial para evaluar enfermedad arterial periférica y venosa (trombosis venosa profunda).
- Arterial: localiza estenosis y oclusiones y mide velocidades; complementa al índice tobillo-brazo (<0,9 anormal), que en diabéticos puede ser falsamente alto (>1,3) por calcificación.
- Indicado ante pulsos ausentes, claudicación, úlcera isquémica o gangrena, y antes de amputar o resecar tejido en pie diabético.
- Venoso: incompresibilidad de la vena = TVP; útil en insuficiencia venosa crónica.
- Operador dependiente; si muestra lesión revascularizable se completa con angio-TAC o arteriografía. El médico general emplea el informe para derivar.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 72 años, con DM2 de 20 años y enfermedad renal crónica, refiere claudicación de pantorrillas. Sus pulsos pedios son débiles, pero el índice tobillo-brazo resulta 1,5. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Descartar enfermedad arterial, porque el índice es normal

B Solicitar electromiografía

C Indicar amputación

D Considerar el índice no confiable por calcificación arterial y realizar ecografía Doppler arterial o índice dedo-brazo

E Repetir el mismo índice en 1 año

Respuesta D. Un ITB sobre 1,3-1,4 indica arterias no compresibles por calcificación de la media, frecuente en diabéticos y en enfermedad renal, y no es confiable. Con claudicación y pulsos débiles se estudia con ecografía Doppler arterial (morfología de onda, estenosis) o índice dedo-brazo, porque las arterias digitales suelen respetarse.

▶ VER CLASE 1.02.4.009 Electrocardiograma

NIVEL REALIZA, INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 4.3 · Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato

QUÉ HAY QUE SABER

- Técnica: 12 derivaciones, paciente en reposo, electrodos precordiales V1–V6 bien ubicados; velocidad 25 mm/s.
- En el diabético: la isquemia puede ser silente (neuropatía autonómica); buscar ondas Q, alteraciones del ST-T y bloqueos en el control basal.
- Hipokalemia (en tratamiento de CAD con insulina): T aplanada, ST descendido y onda U prominente; arritmias ventriculares.
- Hiperkalemia: T alta y picuda, PR largo, QRS ancho, ritmo sinusoidal; urgencia (gluconato de calcio).
- ECG en todo diabético al ingreso al PSCV y periódicamente; en CAD/EHH monitorizar ritmo mientras se repone potasio.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 30 años con DM1 ingresa con cetoacidosis diabética: glicemia 520 mg/dL, pH 7,08 y bicarbonato 6 mEq/L. Se inicia hidratación con suero fisiológico. El potasio aún no está disponible, pero el ECG muestra ondas T aplanadas, depresión del ST y ondas U prominentes. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la insulina?**

A Postergar la insulina y reponer potasio, porque el ECG sugiere hipokalemia

B Iniciar insulina en bolo inmediatamente

C Administrar bicarbonato antes de todo

D Administrar gluconato de calcio por hiperkalemia

E Iniciar insulina subcutánea

Respuesta A. Ondas T aplanadas, depresión del ST y ondas U sugieren hipokalemia. La insulina introduce potasio a las células y puede precipitar arritmias graves. Mientras llega el potasio, el ECG orienta: si sugiere hipokalemia (o K bajo 3,3 mEq/L) se repone potasio antes de iniciar insulina. Las T picudas sugerirían hiperkalemia.

▶ VER CLASE 1.02.4.010 Electromiografía

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.19 · Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Estudia la conducción nerviosa y la actividad muscular; diferencia neuropatía axonal de desmielinizante y localiza atrapamientos.
- Indicación: neuropatía atípica (asimétrica, motora predominante, rápidamente progresiva), sospecha de túnel carpiano antes de cirugía, radiculopatía o miopatía.
- No se usa para el tamizaje de la neuropatía diabética, que se hace con monofilamento de 10 g anual.
- En polineuropatía diabética: patrón axonal sensitivo-motor distal y simétrico; túnel carpiano: latencia distal del mediano prolongada en la muñeca.
- El médico general emplea el informe para confirmar el diagnóstico y derivar (neurología, cirugía de mano).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 52 años, diabética, refiere parestesias nocturnas en el pulgar, índice y medio de la mano derecha que la despiertan y mejoran al sacudir la mano. Tiene signos de Phalen y Tinel positivos y leve atrofia tenar. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico y evaluar su severidad?**

A Radiografía de muñeca

B Ecocardiograma

C RM de columna cervical

D Hemoglobina glicosilada

E Electromiografía con velocidad de conducción nerviosa

Respuesta E. El cuadro es un síndrome del túnel carpiano (atrapamiento del nervio mediano), más frecuente en diabéticos. La electromiografía con estudio de conducción nerviosa confirma la lesión, mide su severidad y la diferencia de una radiculopatía C6-C7 o de la polineuropatía diabética. Con atrofia tenar, la indicación es quirúrgica.

▶ VER CLASE 1.02.4.011 Estudio funcional hepático

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.2 · Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Patrón hepatocelular: transaminasas elevadas (ALT predominante en virus/NASH); AST/ALT >2 con GGT y VCM altos sugiere alcohol; >1.000 UI/L: virus, fármacos (paracetamol) o isquemia.
- Patrón colestásico: FA y GGT elevadas con o sin bilirrubina directa; estudiar vía biliar con ecografía.
- Función de síntesis: tiempo de protrombina/INR (el mejor marcador de gravedad en la hepatitis aguda y criterio de derivación a trasplante) y albúmina.
- En el diabético con transaminasas levemente elevadas: pensar en hígado graso metabólico (AST/ALT <1, ecografía con hígado brillante).
- Antes de iniciar estatinas y en seguimiento de fármacos hepatotóxicos; la elevación leve de transaminasas no contraindica las estatinas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 50 años, que bebe 6 vasos de vino diarios, tiene GOT 180 U/L, GPT 70 U/L, GGT 420 U/L, bilirrubina 1,2 mg/dL y tiempo de protrombina 85%. No usa fármacos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hepatitis viral aguda

B Coledocolitiasis

C Daño hepático por alcohol

D Hepatitis autoinmune

E Hemocromatosis

Respuesta C. Una relación GOT/GPT mayor de 2, con transaminasas bajo 300 U/L y GGT muy elevada, es el patrón típico del daño hepático alcohólico. La hepatitis viral aguda suele dar transaminasas sobre 1.000 U/L con predominio de GPT, y la coledocolitiasis da un patrón colestásico con fosfatasa alcalina alta y dolor.

▶ VER CLASE 1.02.4.012 Evaluación nutricional

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.6 · Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Antropometría: IMC (bajo peso <18,5; sobrepeso 25–29,9; obesidad ≥30; en adulto mayor normal 23–28), circunferencia de cintura y de pantorrilla, pliegues.
- Historia: ingesta (encuesta de 24 h), baja de peso involuntaria (>5 % en 1 mes o >10 % en 6 meses es significativa), síntomas digestivos y capacidad funcional.
- Herramientas de tamizaje: valoración global subjetiva (VGS), MNA en adulto mayor (<17 desnutrición, 17–23,5 riesgo), NRS-2002 en hospitalizados.
- Laboratorio: albúmina (crónica), prealbúmina (aguda), recuento de linfocitos, colesterol; balance nitrogenado para el catabolismo.
- En niños: P/T en menores de 5 años e IMC/E de 5 a 19 años según DE. Interpretar en conjunto, ningún parámetro aislado basta.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 45 años mide 1,75 m y pesa 75 kg (IMC 24,5 kg/m²), pero su circunferencia de cintura es de 104 cm. Tiene una glicemia de ayuno alterada. **¿Cuál es la interpretación más adecuada de su evaluación nutricional?**

A Estado nutricional normal, sin riesgo adicional

B Desnutrición leve

C IMC normal con obesidad abdominal, que implica mayor riesgo cardiometabólico

D Obesidad grado II

E La cintura no tiene valor si el IMC es normal

Respuesta C. El IMC no distingue grasa de músculo ni su distribución. Una cintura sobre 102 cm en hombres (o sobre 90 cm con criterios para población latinoamericana) indica obesidad abdominal, con mayor riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular aun con IMC normal. La evaluación nutricional del adulto incluye peso, talla, IMC y cintura.

▶ VER CLASE 1.02.4.013 Examen de orina completa

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.15 · Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Incluye examen físico-químico (densidad, pH, glucosa, proteínas, cetonas, nitritos, leucocitos, sangre) y sedimento (leucocitos, eritrocitos, cilindros, cristales, bacterias).
- ITU: piuria (>5–10 leucocitos/campo), bacterias y nitritos positivos; cilindros leucocitarios indican origen renal. Siempre confirmar con urocultivo.
- Glomerular: hematíes dismórficos y cilindros hemáticos (glomerulonefritis); proteinuria marcada y cuerpos grasos (síndrome nefrótico).
- Glucosuria aparece con glicemia >180 mg/dL (o con iSGLT2); cetonuria en CAD o ayuno.
- Muestra de segundo chorro, con aseo genital y procesada antes de 2 horas; la contaminación da células epiteliales abundantes.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 30 años presenta orina color 'coca-cola' y edema palpebral 2 semanas después de una faringitis. Su presión arterial es 150/95 mmHg. **¿Qué hallazgo en el examen de orina completa confirma el origen glomerular de la hematuria?**

A Cristales de oxalato de calcio

B Leucocitos abundantes con bacterias

C Nitritos positivos

D Cilindros hemáticos y glóbulos rojos dismórficos

E Hematuria con coágulos

Respuesta D. Los cilindros hemáticos y los glóbulos rojos dismórficos (acantocitos) indican sangrado de origen glomerular, aquí una probable glomerulonefritis postestreptocócica. La hematuria con coágulos sugiere origen urológico (vía urinaria), y nitritos con leucocitos y bacterias orientan a infección urinaria.

▶ VER CLASE 1.02.4.014 Examen de orina semicuantitativa

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.4 · Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Tira reactiva de lectura rápida: glucosa, cetonas, proteínas, sangre, leucocitos (esterasa), nitritos, pH y densidad.
- Nitritos positivos sugieren bacterias Gram negativas (E. coli); esterasa leucocitaria indica piuria. Tira negativa en ambos hace poco probable la ITU no complicada.
- Proteínas en tira detectan principalmente albúmina >300 mg/L; no sirve para tamizar albuminuria moderada (usar RAC).
- Sangre positiva sin hematíes en el sedimento: mioglobinuria o hemoglobinuria (rabdomiólisis, hemólisis).
- Es orientador: confirmar con sedimento, urocultivo o cuantificación según el hallazgo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 30 años consulta por disuria, polaquiuria y urgencia miccional de 1 día. Refiere que orina cada 30 minutos. La tira reactiva de orina muestra leucocitos (+++) y nitritos negativos. **¿Cuál es la interpretación más adecuada del resultado de nitritos?**

A Descarta una infección urinaria

B Indica que la infección es viral

C Indica infección por E. coli

D Indica contaminación de la muestra

E Un nitrito negativo no descarta infección, porque requiere tiempo de permanencia de la orina en la vejiga y bacterias reductoras de nitratos

Respuesta E. Los nitritos se forman cuando enterobacterias como E. coli reducen nitratos, lo que requiere unas 4 horas de orina en la vejiga. Con polaquiuria intensa o gérmenes no reductores (Enterococcus, S. saprophyticus) pueden ser negativos. Es específico pero poco sensible: un nitrito negativo no descarta ITU.

▶ VER CLASE 1.02.4.015 Glicemia capilar

NIVEL REALIZA, INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 2.4 · Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante
Diabetes 3.2 · Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis
Diabetes 3.3 · Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado
Diabetes 3.4 · Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate

QUÉ HAY QUE SABER

- Herramienta de automonitoreo y de urgencia (hemoglucotest); no sirve para diagnosticar diabetes (usar glicemia venosa).
- Metas en DM2: preprandial 80–130 mg/dL y postprandial <180; en DMG ayuno 70–90/95, 1 h <140 y 2 h <120. Hospitalizados: 140–180.
- Frecuencia: DMG 4–6 veces/día; usuarios de insulina según esquema; el ayuno guía la titulación de la NPH nocturna (+2 UI si 131–180, +4 UI si >180).
- Hiperglicemia matinal: medir a las 3 AM; <70 = Somogyi (bajar la basal), >100 = fenómeno del alba (subir o retrasar la basal).
- Técnica: manos limpias y secas, punción lateral del pulpejo, primera gota válida si la piel está limpia; error en hipoperfusión, anemia o hematocrito extremo.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 78

Un paciente de 57 años, diabético desde hace 15 años, en tratamiento con metformina 1 gramo cada 12 horas e insulina NPH nocturna 10 UI por vía subcutánea. Respecto al control con glicemias capilares, **¿cuál es el esquema de control más adecuado?**

A Controlar dos horas después del desayuno

B Controlar dos horas después del almuerzo

C Controlar a primera hora en la mañana, en ayunas

D Controlar antes de cada comida

E Controlar antes de la administración de la insulina NPH nocturna

Respuesta C. En el esquema basal con NPH nocturna, la glicemia que refleja esa insulina y guía su titulación es la de ayuno, a primera hora de la mañana.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Gestante de 30 semanas con diabetes gestacional, en plan de alimentación hace 2 semanas. Trae su registro de hemoglucotest: glicemias de ayuno entre 98 y 108 mg/dL en 6 de 14 mediciones; glicemias 1 hora postprandiales entre 112 y 132 mg/dL en todas las mediciones. Ecografía con circunferencia abdominal fetal en percentil 60. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener la dieta, ya que los postprandiales están en meta

B Iniciar insulina NPH nocturna

C Iniciar insulina rápida antes de cada comida

D Iniciar glibenclamida en la mañana

E Aumentar la frecuencia de hemoglucotest y reevaluar en un mes

Respuesta B. Metas de glicemia capilar en la diabetes gestacional: ayuno bajo 90–95 mg/dL y 1 hora postprandial bajo 140 mg/dL. Aquí el 43 % de los ayunos está fuera de meta (más del 20 %) y los postprandiales están bien: se indica insulina NPH nocturna, que corrige el ayuno.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

¿Cuál es el rango de glicemia recomendado como objetivo terapéutico en la gran mayoría de los pacientes diabéticos adultos no gestantes hospitalizados en servicios de medicina interna? **Seleccione la alternativa correcta.**

A 70 a 100 mg/dL

B 80 a 130 mg/dL

C 140 a 180 mg/dL

D 180 a 250 mg/dL

E Menor a 110 mg/dL en todo momento

Respuesta C. La meta en el hospitalizado, crítico o no crítico, es 140–180 mg/dL. Bajar a < 110 mg/dL no reduce las infecciones y aumenta las hipoglicemias severas y la mortalidad (NICE-SUGAR).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 38 años, sin diabetes ni otros antecedentes, consulta por episodios de temblor, sudoración y palpitaciones 2 a 3 horas después de comer, que ceden al ingerir alimentos. Trae un registro de un glucómetro prestado con valores de 58, 62 y 64 mg/dL durante los síntomas. Examen físico normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada para confirmar una hipoglicemia?**

A Diagnosticar hipoglicemia reactiva con el registro del glucómetro

B Iniciar dieta fraccionada sin más estudio

C Documentar una glicemia plasmática venosa baja durante los síntomas, que se corrijan al normalizarla

D Solicitar hemoglobina glicosilada

E Solicitar insulinemia basal de ayuno

Respuesta C. En una persona sin diabetes, la hipoglicemia se confirma con la tríada de Whipple usando glicemia plasmática (bajo 55 mg/dL), no con glucómetro, que es impreciso en rangos bajos. La glicemia capilar sirve para el automonitoreo y la urgencia del diabético, no para diagnosticar hipoglicemia en un no diabético.

▶ VER CLASE 1.02.4.016 Glicemia venosa

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 1.2 · Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS

QUÉ HAY QUE SABER

- Plasmática venosa con 8 h de ayuno: <100 normal; 100–125 glicemia de ayuno alterada (pedir PTGO); ≥126 diabetes si se confirma en otro día.
- Glicemia al azar ≥200 mg/dL con síntomas (poliuria, polidipsia, polifagia, baja de peso) confirma diabetes sin repetir.
- Tamizaje en APS a quien tenga IMC ≥25 + 1 factor de riesgo o ≥45 años; normal: repetir en 3 años.
- Primera ≥126 y segunda <126 (discordante): PTGO para definir.
- En el embarazo los cortes bajan: ayuno ≥100 en dos ocasiones = DMG; en el hospitalizado el estrés la eleva (usar HbA1c).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 52 años, asintomático, se realiza en un examen preventivo una glicemia venosa de ayuno, que resulta 132 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Repetir la glicemia venosa de ayuno otro día para confirmar

B Diagnosticar diabetes e iniciar insulina

C Diagnosticar prediabetes

D Solicitar una glicemia capilar para confirmar

E Descartar diabetes por estar asintomático

Respuesta A. El diagnóstico de diabetes requiere glicemia venosa de ayuno ≥126 mg/dL en 2 ocasiones en días distintos, o glicemia al azar ≥200 mg/dL con síntomas, o PTGO a las 2 horas ≥200 mg/dL. En un asintomático con un solo valor alterado se confirma repitiendo la glicemia venosa. La glicemia capilar no sirve para diagnosticar.

▶ VER CLASE 1.02.4.017 Hemoglobina glicosilada

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 1.2 · Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS
Diabetes 1.4 · Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas
Diabetes 2.1 · Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL

QUÉ HAY QUE SABER

- Refleja la glicemia promedio de los últimos 2–3 meses; se usa para diagnóstico (≥6,5 % en laboratorio estandarizado, confirmar en asintomático) y control.
- Prediabetes 5,7–6,4 %. Metas: <7 % estándar, <6,5 % joven sin riesgo de hipoglicemia, <7,5 % adulto mayor activo, <8–8,5 % frágil.
- Control cada 3 meses si está fuera de meta o se cambió el tratamiento; cada 6 meses si está estable en meta.
- Examen de elección en el hospitalizado o con corticoides: ≥6,5 % indica diabetes previa.
- Falsamente baja en hemólisis, hemorragia aguda, hemodiálisis o embarazo; falsamente alta en ferropenia prolongada y esplenectomía. La fructosamina refleja 2–3 semanas.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 106

Un paciente de 66 años es hospitalizado por una neumonía adquirida en la comunidad. En su hemoglucotest de ingreso, se constata una glicemia capilar de 256 mg/dl. **¿Cuál de los siguientes exámenes confirma el diagnóstico de diabetes?**

A Glicemia de ayuno > 126 mg/dl
B Prueba de tolerancia a la glucosa > 200 mg/dl, postcarga de glucosa
C Hemoglobina glicosilada > 6,5%
D Prueba HOMA > 2,6
E Albuminuria/creatininuria > 0,3

Respuesta C. En un paciente con enfermedad aguda, la glicemia y la PTGO se alteran por el estrés. La HbA1c refleja los 2–3 meses previos y no se modifica por la neumonía, por eso es el examen que confirma la diabetes en el hospitalizado.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 52 años con DM2 de 3 años de evolución, en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas. Antecedente de mioma uterino con metrorragia abundante, por lo que recibió 2 unidades de glóbulos rojos hace 3 semanas. Trae HbA1c de 6,1 %, pero su registro de glicemias capilares de ayuno muestra valores entre 180 y 220 mg/dL. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Está en meta; mantener el tratamiento
B La HbA1c está falsamente baja por la transfusión y la pérdida de sangre
C El glucómetro está mal calibrado; confiar en la HbA1c
D Debe reducirse la metformina por riesgo de hipoglicemia
E La HbA1c está falsamente alta por la anemia ferropénica

Respuesta B. La HbA1c refleja la glucosa unida a la hemoglobina durante la vida del glóbulo rojo. La hemorragia y la transfusión reciente renuevan los eritrocitos y la bajan falsamente. Aquí manda el registro de glicemias capilares; se repite la HbA1c en 2–3 meses.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 49 años con DM2 recién diagnosticada, HbA1c inicial 7,8 %. Asintomática, sin baja de peso. Se indica plan de alimentación, actividad física y metformina 850 mg cada 12 horas. Tolera bien el tratamiento y pregunta cuándo debe volver a medirse la HbA1c para saber si el tratamiento funcionó. **¿Cuándo corresponde controlar la HbA1c para evaluar la respuesta?**

A A las 2 semanas
B Al mes
C A los 12 meses
D A los 3 meses
E No es necesario; basta con la glicemia de ayuno

Respuesta D. La HbA1c refleja el promedio glicémico de los 2–3 meses previos, que es la vida media útil del glóbulo rojo. Medirla antes no muestra el efecto real del cambio de tratamiento. Se controla a los 3 meses y, si no está en meta, se intensifica.

▶ VER CLASE 1.02.4.018 Insulinemia

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 3.4 · Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate

QUÉ HAY QUE SABER

- Se interpreta junto a la glicemia de ayuno: HOMA-IR = glicemia × insulina / 405; >2,6 indica resistencia a la insulina (no es diabetes ni prediabetes).
- Resistencia con glicemia normal: estilo de vida (dieta y ejercicio), no metformina de rutina.
- Hipoglicemia en no diabético: muestra crítica con glicemia <55 mg/dL midiendo insulina, péptido C, proinsulina y sulfonilureas.
- Insulina alta + péptido C indetectable: insulina exógena (facticia); insulina y péptido C altos con screening de sulfonilureas negativo: insulinoma.
- No es examen de rutina para diagnosticar diabetes ni para el control; su uso aislado tiene poca utilidad.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 32 años, enfermera de profesión, sin antecedentes médicos conocidos, es traída a urgencias por haber presentado 4 episodios de confusión mental, visión borrosa y sudoración profusa en el último mes. Durante uno de los episodios en el hospital, se constata una glicemia venosa de 38 mg/dL. Los exámenes de laboratorio tomados durante la hipoglicemia revelan: insulina plasmática marcadamente elevada, péptido C indetectable y screening negativo para sulfonilureas en orina. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Insulinoma maligno diseminado

B Síndrome de dumping tardío posprandial

C Administración subrepticia de insulina exógena (hipoglicemia facticia)

D Ingesta accidental o encubierta de glibenclamida

E Insuficiencia suprarrenal primaria autoinmune (Enfermedad de Addison)

Respuesta C. La insulina endógena se libera junto con el péptido C. Insulina muy alta con péptido C indetectable demuestra insulina exógena: hipoglicemia facticia. En el insulinoma y con sulfonilureas, el péptido C está elevado.

▶ VER CLASE 1.02.4.019 Microalbuminuria

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.1 · Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector

QUÉ HAY QUE SABER

- Albuminuria moderada: 30–300 mg/24 h, o RAC 30–299 mg/g en muestra matinal (método preferido actual).
- Primer signo detectable de nefropatía diabética y marcador de riesgo cardiovascular.
- Tamizaje anual: DM2 desde el diagnóstico, DM1 a los 5 años del debut, y en hipertensos.
- Confirmar con 2 de 3 muestras en 3–6 meses; descartar ITU, fiebre, ejercicio intenso, IC descompensada o hiperglicemia grave.
- Confirmada: IECA o ARA-II aunque sea normotenso (nunca ambos) + iSGLT2, control estricto de PA y glicemia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 55 años con DM2 de 6 años, sin síntomas urinarios ni ejercicio intenso reciente, tiene en su control una relación albúmina/creatinina urinaria (RAC) de 85 mg/g, con VFG estimada de 80 mL/min/1,73 m². Es la primera vez que resulta alterada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Diagnosticar nefropatía diabética e iniciar diálisis

B Confirmar repitiendo la RAC: se requieren 2 de 3 muestras alteradas en 3 a 6 meses

C Solicitar biopsia renal

D Descartar el hallazgo porque la VFG es normal

E Solicitar solo una ecografía renal

Respuesta B. Una RAC de 30 a 300 mg/g es albuminuria moderadamente elevada (antes 'microalbuminuria'), marcador precoz de nefropatía diabética y de riesgo cardiovascular. Por su variabilidad (ejercicio, fiebre, ITU, descompensación) se confirma con 2 de 3 muestras alteradas en 3 a 6 meses. Confirmada, se indica IECA o ARA II y se considera iSGLT2.

▶ VER CLASE 1.02.4.020 Nitrogeno urinario

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.6 · Nutrición Clínica: Obesidad, Síndrome Metabólico, Evaluación Nutricional y Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Nitrógeno ureico urinario de 24 horas: estima el catabolismo proteico y permite calcular el balance nitrogenado.
- Balance nitrogenado = (proteínas ingeridas en g / 6,25) − (NUU + 4 g de pérdidas no urinarias).
- Balance negativo: catabolismo (sepsis, trauma, quemados, cirugía mayor, aporte insuficiente); positivo: anabolismo, objetivo del soporte nutricional.
- Requiere recolección completa de orina de 24 h y función renal relativamente conservada; se altera en ERC, diarrea o fístulas.
- Se usa en pacientes hospitalizados con soporte nutricional para ajustar el aporte proteico (habitualmente 1,2–2 g/kg/día en catabólicos).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 40 años, en UCI por politraumatismo, recibe nutrición enteral con 75 g de proteínas al día (12 g de nitrógeno). Para evaluar si el aporte proteico es suficiente, se mide el nitrógeno ureico urinario de 24 horas: 18 g/día. **¿Cuál es la interpretación del balance nitrogenado?**

A Balance positivo: está en anabolismo

B Balance neutro

C Balance negativo de unos 10 g/día: hipercatabolismo con aporte proteico insuficiente

D El nitrógeno urinario no sirve para evaluar el estado nutricional

E Indica insuficiencia renal aguda

Respuesta C. Balance nitrogenado = nitrógeno aportado (proteínas / 6,25) − (nitrógeno ureico urinario + 4 g de pérdidas no urinarias). Aquí: 12 − (18 + 4) = −10 g/día. Un balance negativo indica catabolismo proteico mayor que el aporte, típico del trauma y la sepsis, y obliga a aumentar el aporte proteico.

▶ VER CLASE **1.02.4.021** **Perfil lipídico** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.4 · Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

QUÉ HAY QUE SABER

- Incluye colesterol total, HDL, triglicéridos y LDL (Friedewald: CT − HDL − TG/5, válido si TG <400); ayuno de 9–12 h, sobre todo para TG.
- Meta según riesgo cardiovascular: LDL <55–70 riesgo muy alto, <70 alto, <100 moderado; HDL bajo <40 hombre y <50 mujer; TG normal <150.
- LDL ≥190 con TG normales: sospechar hipercolesterolemia familiar. TG ≥500: prioridad prevenir pancreatitis (fibrato).
- Control a las 6–12 semanas de iniciar o cambiar estatina y luego anual si está en meta.
- Descartar causas secundarias: hipotiroidismo, síndrome nefrótico, colestasis, diabetes descompensada, alcohol, fármacos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 52 años con obesidad y consumo diario de alcohol, en control de salud. Perfil lipídico en ayunas de 12 horas: colesterol total 260 mg/dL, HDL 34 mg/dL, triglicéridos 520 mg/dL. El informe del laboratorio no entrega el valor de LDL. **¿Cuál es la interpretación más adecuada respecto al colesterol LDL?**

A Calcular el LDL con la fórmula de Friedewald: 122 mg/dL

B El LDL no tiene importancia en este paciente

C Repetir el perfil sin ayuno para obtener el LDL

D El LDL es igual al colesterol total menos el HDL

E Con triglicéridos sobre 400 mg/dL la fórmula de Friedewald no es válida; se usa LDL medido en forma directa o el colesterol no HDL

Respuesta E. La fórmula de Friedewald (LDL = colesterol total − HDL − triglicéridos/5) solo es válida con triglicéridos bajo 400 mg/dL. Sobre ese valor sobreestima las VLDL y subestima el LDL. Se pide LDL directo o se usa el colesterol no HDL (aquí 226 mg/dL). Además, con triglicéridos sobre 500 la prioridad es prevenir la pancreatitis.

▶ VER CLASE **1.02.4.022** **Proteiuniria 24 horas** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 4.1 · Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas

QUÉ HAY QUE SABER

- Normal <150 mg/24 h; rango nefrótico >3,5 g/24 h (con albúmina <3 g/dL, edema y dislipidemia = síndrome nefrótico).
- Alternativa más práctica: índice proteinuria/creatininuria en muestra aislada (>3–3,5 equivale a rango nefrótico; ≥0,2 mg/mg es marcador de daño renal).
- Verificar recolección adecuada con la creatininuria de 24 h (aprox. 15–25 mg/kg/día).
- Útil para cuantificar proteinuria en glomerulopatías, preeclampsia (≥300 mg/24 h) y seguir la respuesta al tratamiento.
- En el diabético el tamizaje se hace con RAC, no con orina de 24 h.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 35 años presenta edema progresivo de extremidades inferiores y palpebral de 3 semanas. Tiene orina espumosa, albúmina plasmática de 2,1 g/dL y colesterol total de 340 mg/dL. El sedimento urinario no muestra cilindros hemáticos. **¿Qué resultado de proteinuria de 24 horas confirma el síndrome nefrótico?**

A Mayor de 3,5 g/24 h

B 500 mg/24 h

C 1,5 g/24 h

D 150 mg/24 h

E Proteinuria negativa

Respuesta A. El síndrome nefrótico del adulto se define por proteinuria mayor de 3,5 g/24 horas, hipoalbuminemia bajo 3 g/dL, edema y dislipidemia. La proteinuria normal es menor de 150 mg/24 horas. Una alternativa práctica es el índice proteína/creatinina en orina aislada mayor de 3 a 3,5 g/g.

▶ VER CLASE **1.02.4.023** **Test de esfuerzo** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 1.5 · Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular

QUÉ HAY QUE SABER

- Prueba de ejercicio en cinta con ECG y PA continuos; evalúa isquemia inducible, capacidad funcional y respuesta presora.
- En el diabético no se pide de rutina antes de iniciar ejercicio moderado; se considera antes de ejercicio vigoroso en sedentarios con alto riesgo cardiovascular, síntomas o ECG basal alterado.
- Positivo: infradesnivel del ST ≥1 mm horizontal o descendente, angina, caída de la PA o arritmias; indica derivar a cardiología.
- Contraindicaciones: SCA reciente, estenosis aórtica severa sintomática, IC descompensada, arritmias no controladas; ECG basal no interpretable (BCRI, marcapasos) requiere test con imagen.
- El médico general emplea el informe para prescribir la intensidad del ejercicio y derivar si es positivo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 58 años, diabético e hipertenso, refiere desde hace 2 meses opresión retroesternal al subir 2 pisos de escalera, que cede en 3 minutos con el reposo. Su ECG de reposo es normal y puede caminar sin limitaciones ortopédicas. **¿Cuál es el examen inicial más adecuado para el estudio de isquemia?**

A Coronariografía de urgencia

B Test de esfuerzo (ergometría)

C Holter de ritmo

D Troponinas seriadas en urgencia

E Ecocardiograma transesofágico

Respuesta B. Es una angina estable: de esfuerzo, cede con el reposo y su patrón no ha cambiado en 2 meses. Si el paciente puede ejercitarse y su ECG basal es interpretable, el test de esfuerzo es el examen inicial no invasivo para detectar isquemia y estratificar riesgo. Si no, se usan pruebas con imagen.

▶ VER CLASE 1.02.4.024 Test de tolerancia a la glucosa

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 1.2 · Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS
Diabetes 1.3 · Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)

QUÉ HAY QUE SABER

- PTGO: glicemia basal y a las 2 h tras 75 g de glucosa, con 3 días de dieta normal previa y ayuno de 8 h.
- No embarazada: 2 h <140 normal; 140–199 intolerancia a la glucosa; ≥200 diabetes.
- Indicación: glicemia de ayuno 100–125 o resultado discordante (primera ≥126 y segunda <126). No pedir si ya hay criterio diagnóstico de diabetes.
- Embarazada: universal a las 24–28 semanas; basal ≥100 o 2 h ≥140 = DMG (basta un valor). Repetir a las 32–34 sem en alto riesgo; PTGO a las 6–12 semanas posparto.
- No es válida durante enfermedad aguda o con corticoides (usar HbA1c).

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 158

Mujer asintomática de 46 años de edad, con IMC de 24. Tiene antecedente de diabetes gestacional con su último embarazo. Se practica una glicemia en ayunas que resulta en 112 mg/dl. **La conducta más adecuada es:**

A Repetir la glicemia en ayunas

B Practicar niveles de hemoglobina glicosilada

C Indicar metformina

D Realizar control de glicemia en 6 meses

E Solicitar curva de tolerancia a la glucosa

Respuesta E. Glicemia de ayuno entre 100 y 125 mg/dL en una mujer no embarazada: glicemia de ayuno alterada. La conducta es la PTGO con 75 g; repetir la glicemia de ayuno no aporta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 95

Un paciente de 39 años, con antecedente de obesidad, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, que muestra una glicemia basal de 117 mg/dl y postcarga de 75 gramos de glucosa de 136 mg/dl. **El diagnóstico más probable es:**

A Normal

B Diabetes mellitus 2

C Intolerancia a la glucosa oral

D Diabetes mellitus 1

E Prediabetes

Respuesta E. Basal 117 mg/dL: glicemia de ayuno alterada. Postcarga 136 mg/dL (< 140): sin intolerancia ni diabetes. La GAA es una forma de prediabetes.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Embarazada de 33 años, multípara de 2, cursando 32 semanas. Glicemia de ayuno de ingreso 84 mg/dL. PTGO con 75 g a las 26 semanas: 82 mg/dL basal y 128 mg/dL a las 2 horas. En la ecografía actual el feto está en percentil 95 de peso y el ILA es de 26 cm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Repetir la PTGO con 75 g ahora

B Mantener control prenatal habitual

C Iniciar insulina NPH nocturna

D Solicitar hemoglobina glicosilada

E Solicitar glicemia de ayuno cada 2 semanas

Respuesta A. La PTGO de las 24–28 semanas fue normal, pero aparecen factores de alto riesgo: feto grande y polihidramnios. En ese caso se repite la PTGO entre las 32 y 34 semanas para no pasar por alto una diabetes gestacional tardía. Sin diagnóstico no corresponde iniciar insulina.

▶ VER CLASE **1.02.4.025** **Urocultivo y antibiograma** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.4 · Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico de ITU: ≥100.000 UFC/mL en orina de segundo chorro (menos en sondeo o punción); tomar siempre antes del antibiótico en ITU complicada, pielonefritis, embarazo y recurrencias.
- Bacteriuria asintomática: solo se trata en embarazadas y antes de procedimientos urológicos; no tratar en diabéticos ni ancianos.
- Agente más frecuente: E. coli. El antibiograma guía el ajuste del tratamiento empírico; buscar BLEE en hospitalizados o con uso previo de antibióticos.
- Pielonefritis ambulatoria: control a las 48–72 h revisando respuesta y cultivo; hospitalizar en embarazo, intolerancia oral, sepsis, obstrucción o DM descompensada.
- Contaminación: varios gérmenes o recuentos bajos con células epiteliales; repetir con buena técnica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 62 años, diabética, presenta fiebre de 39 °C, calofríos, dolor lumbar derecho y puño percusión positiva. Está hemodinámicamente estable. Hace 3 meses recibió ciprofloxacino por una cistitis. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto del urocultivo?**

A Iniciar antibiótico sin solicitar urocultivo

B Solicitar urocultivo solo si no responde en 1 semana

C Esperar el resultado del urocultivo (48 a 72 horas) para iniciar antibiótico

D Tomar urocultivo con antibiograma antes de iniciar el antibiótico empírico, y ajustar según el resultado

E Usar la orina recolectada el día anterior

Respuesta D. En una pielonefritis, especialmente en diabéticos o con uso reciente de antibióticos, se toma urocultivo con antibiograma (segundo chorro, previo aseo) antes del primer antibiótico, sin retrasar el tratamiento empírico. El antibiograma permite ajustar ante resistencia, frecuente a quinolonas en Chile. Esperar el resultado para tratar es peligroso.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

3 códigos

▶ VER CLASE **1.02.5.001** **Curaciones básicas del pié diabético** NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.3 · Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicada en úlceras Wagner 0–2 de manejo ambulatorio; Wagner 3–5 (absceso, osteomielitis, gangrena) se hospitalizan.
- Técnica: lavado con suero fisiológico a presión, retiro de esfacelo, tejido necrótico e hiperqueratosis (desbridamiento), y apósito que mantenga un ambiente húmedo fisiológico (curación avanzada).
- Evitar antisépticos citotóxicos y pomadas; no hisopar la superficie para cultivo (tomar tejido profundo).
- Descarga de presión obligatoria (reposo, férula de contacto total, calzado especial): sin descarga ninguna úlcera cicatriza.
- Evaluar en cada curación signos de infección (celulitis, secreción, mal olor), profundidad con estilete (si toca hueso: osteomielitis) y pulsos; derivar si empeora o hay isquemia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 66 años con DM2 y polineuropatía. Úlcera plantar de 1,5 cm bajo la cabeza del 2.º metatarsiano, superficial, con bordes de hiperqueratosis y fondo con algo de tejido esfacelado. Sin eritema, calor ni secreción purulenta; estilete óseo negativo. Pulsos pedios presentes. **¿Cuál es el manejo local más adecuado de la úlcera?**

A Lavado con povidona yodada y agua oxigenada, y gasa seca

B Antibiótico tópico y dejar la úlcera expuesta al aire

C Lavado con suero fisiológico, desbridamiento del esfacelo y la hiperqueratosis, apósito que mantenga un ambiente húmedo y descarga de la zona

D Cefadroxilo oral por 14 días y reposo

E Hospitalizar para desbridamiento quirúrgico

Respuesta C. Úlcera neuropática Wagner 1 sin infección: manejo ambulatorio con curación avanzada. Se lava con suero fisiológico, se retira el tejido desvitalizado y la callosidad, se usa un apósito que mantenga un ambiente húmedo fisiológico y se descarga la zona. Los antisépticos dañan el tejido de granulación y sin infección no se indican antibióticos.

▶ VER CLASE **1.02.5.002** **Evaluacion nutricional subjetiva** NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.14 · Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios

QUÉ HAY QUE SABER

- Valoración global subjetiva (VGS): método clínico simple, validado, basado en historia y examen físico, sin exámenes de laboratorio.

- Historia: cambio de peso en 6 meses y últimas 2 semanas, cambios en la ingesta, síntomas gastrointestinales (>2 semanas), capacidad funcional y demanda metabólica de la enfermedad.
- Examen: pérdida de grasa subcutánea (tríceps, tórax), atrofia muscular (cuádriceps, deltoides, temporal), edema de tobillos o sacro y ascitis.
- Clasifica en A (bien nutrido), B (desnutrición moderada o en riesgo) y C (desnutrición severa).
- B o C: indicar intervención nutricional y derivar a nutricionista; útil antes de cirugías mayores y al ingreso hospitalario.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 66 años será operado de un cáncer gástrico. En la evaluación nutricional subjetiva global refiere baja de peso de 12% en 6 meses, ingesta reducida a la mitad hace 1 mes, náuseas frecuentes y capacidad funcional disminuida; al examen tiene pérdida de grasa subcutánea y de masa muscular temporal. **¿Cómo se clasifica según la evaluación subjetiva global y qué implica?**

A. A (bien nutrido): operar sin intervención nutricional
B. B (moderadamente desnutrido): no requiere intervención
C. Requiere exámenes de laboratorio para poder clasificarlo
D. No es aplicable en pacientes oncológicos
E. C (severamente desnutrido): iniciar soporte nutricional preoperatorio

Respuesta E. La evaluación subjetiva global es clínica (anamnesis y examen), sin exámenes: considera cambio de peso, ingesta, síntomas digestivos, capacidad funcional, estrés metabólico y signos físicos. Una baja sobre 10% en 6 meses con pérdida de grasa y músculo clasifica como C, desnutrición severa, y justifica soporte nutricional preoperatorio por 7 a 14 días.

▶ VER CLASE 1.02.5.003 Fondo de ojo

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.2 · Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Técnica: oftalmoscopio directo en sala oscura, idealmente con pupila dilatada (tropicamida); comenzar con el rojo pupilar, luego papila, vasos, mácula y periferia.
- Contraindicación de midriasis: cámara anterior estrecha (riesgo de glaucoma agudo); evitar en pacientes con lesión neurológica en observación.
- Diabetes: microaneurismas (lesión más precoz), hemorragias, exudados duros y algodonosos; neovasos = proliferativa, derivar urgente.
- Hipertensión: estrechamiento arteriolar, cruces arteriovenosos, hemorragias en llama; edema de papila en emergencia hipertensiva o HTEC.
- Rojo pupilar ausente con pérdida visual súbita indolora: hemorragia vítrea. En APS el tamizaje se hace con retinografía no midriática anual.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Joven de 19 años con DM1 diagnosticada a los 16 años, en esquema basal-bolo, HbA1c 7,4 %. Nunca se ha realizado un fondo de ojo. Su padre, DM2 diagnosticado la semana pasada a los 50 años, también consulta. Ninguno refiere síntomas visuales. **¿Cuándo corresponde realizar el primer fondo de ojo de tamizaje a cada uno?**

A. Ambos de inmediato
B. Al hijo de inmediato y al padre en 5 años
C. Al hijo a los 30 años y al padre a los 5 años del diagnóstico
D. Ambos solo si presentan síntomas visuales
E. Al hijo a los 5 años del debut, es decir a los 21 años, y al padre de inmediato

Respuesta E. En la DM2 el fondo de ojo se realiza al momento del diagnóstico, porque la enfermedad pudo llevar años sin detectarse, y luego cada año. En la DM1 el tamizaje parte a los 5 años del debut, ya que la retinopatía no aparece antes. La retinopatía es silenciosa: se busca, no se espera a los síntomas.

03
ENDOCRINOLOGÍA

42 CÓDIGOS

141 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	23
Situaciones clínicas de urgencia	5
Conocimientos generales	3
Exámenes e imagenología	11

Situaciones clínicas

23 códigos

▶ VER CLASE **1.03.1.001** **Bocio**

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 7.9 · Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF

QUÉ HAY QUE SABER

- Bocio: aumento de volumen tiroideo difuso o nodular; puede ser eutiroideo, hipotiroideo (Hashimoto, bocio firme) o hipertiroideo (Graves difuso con soplo, bocio multinodular tóxico).
- Primer examen: TSH (y T4 libre si está alterada), porque define la conducta; luego ecografía tiroidea para morfología y nódulos.
- PAAF solo en nódulos con criterios ecográficos (TI-RADS y tamaño); cintigrama solo si la TSH está suprimida.
- Inicial: corregir la función (levotiroxina si hay hipotiroidismo; tiamazol y propranolol si hay hipertiroidismo). La levotiroxina supresora para reducir bocio o nódulos está en desuso.
- Derivar a endocrinología o cirugía si hay síntomas compresivos (disfagia, disfonía, estridor), bocio grande (>80 g), crecimiento rápido, nódulo sospechoso o hipertiroidismo para terapia definitiva.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 35 años consulta por aumento de volumen cervical anterior difuso, indoloro y de crecimiento lento. No tiene síntomas de hipo ni de hipertiroidismo, ni síntomas compresivos. Al examen la tiroides está aumentada de tamaño en forma simétrica, blanda, sin nódulos palpables. **¿Cuál es el examen inicial más adecuado?**

A TSH

B Punción aspirativa con aguja fina (PAAF) de tiroides

C Cintigrama tiroideo

D TAC de cuello

E Tiroglobulina

Respuesta A. Ante todo bocio, lo primero es evaluar la función tiroidea con TSH (y T4 libre si está alterada), porque define la conducta. La ecografía tiroidea complementa la evaluación morfológica y de nódulos. La PAAF solo se indica en nódulos según criterios ecográficos, y el cintigrama en hipertiroidismo con TSH suprimida.

▶ VER CLASE **1.03.1.002** **Hipotiroidismo**

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 1.2 · Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina
Endocrinología 1.3 · Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas
Endocrinología 1.4 · Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito
Endocrinología 1.5 · Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio)

QUÉ HAY QUE SABER

- Causa principal en Chile: tiroiditis de Hashimoto (anti-TPO y anti-Tg positivos); otras: radioyodo, tiroidectomía, amiodarona, litio. Clínica: astenia, intolerancia al frío, constipación, aumento de peso moderado, piel seca, bradicardia, relajación lenta del aquiliano.
- Diagnóstico: TSH alta con T4 libre baja (clínico) o normal (subclínico). Puede dar dislipidemia, anemia, hiponatremia y CK elevada, que se corrigen con levotiroxina (no partir con estatinas).
- Subclínico: tratar siempre si TSH ≥10; con TSH 4,5–9,9 tratar si hay embarazo o deseo de embarazo, anti-TPO positivos, bocio, síntomas o enfermedad cardiovascular; mayores de 70–80 años asintomáticos con TSH <10, observar.
- Levotiroxina (GES): 1,6 mcg/kg/día de peso ideal en el joven sano; adulto mayor o coronario 25–50 mcg/día (12,5 si coronariopatía grave) subiendo 12,5–25 mcg cada 6–8 semanas. Tomar en ayunas con agua, 30–60 min antes del desayuno, separada 4 h de hierro, calcio, antiácidos e IBP.
- Seguimiento: TSH a las 6–8 semanas de cada cambio, meta 0,5–2,5 mUI/L; antes de subir la dosis, revisar cómo la toma. Embarazo: subir la dosis 20–30 % al confirmarlo. Hipotiroidismo central: controlar con T4 libre y descartar insuficiencia suprarrenal antes de iniciar.

PREGUNTAS · 12

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 15

Una paciente de 27 años, en amenorrea por lactancia, presenta un cuadro de astenia y malestar general, constipación y dificultades para concentrarse, asociado a intolerancia al frío. Además, refiere que no ha podido bajar de peso. Al examen físico tiene FC: 67x', PA: 120/80 mmHg, se aprecia piel seca y cabello ralo, sin otras alteraciones en el examen físico segmentario. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran TSH: 14,7 UI/L, T4 libre: 0,6 ng/dl, T3: 46 ng/dl. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?**

A Iniciar tratamiento con levotiroxina oral

B Solicitar ecografía tiroidea

C Solicitar cintigrafía tiroidea

D Solicitar prueba de captación de yodo radiactivo

E Repetir los exámenes en 6 semanas

Respuesta A. Hipotiroidismo clínico: síntomas y T4 libre baja con TSH alta. Se inicia levotiroxina. Aun si fuera subclínico, una TSH sobre 10 obliga a tratar. Las imágenes no cambian la conducta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 21

Una paciente de 17 años, con hábitos de vida sedentarios y obesidad se realiza exámenes de control, en los que presenta TSH: 6,5 UI/L, T4 libre: 1,5 ng/dl (VN: 0,7 a 1,9 ng/dl) y T3 libre 300 pg/dl (VN: 130 a 450 pg/dl). **La conducta más adecuada es:**

A Iniciar levotiroxina

B Controlar hormonas tiroideas en 6 meses

C Solicitar anticuerpos antiperoxidasa tiroidea

D Solicitar ecografía tiroidea

E Solicitar cintigrafía tiroidea con yodo radiactivo

Respuesta B. Hipotiroidismo subclínico (TSH 6,5 con T4 libre normal) sin factores agravantes: no requiere tratamiento y se controla. La obesidad no es un criterio para iniciar levotiroxina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 110

Una paciente de 35 años presenta un cuadro de astenia importante. Al examen físico tiene FC: 59x', PA: 110/70 mmHg, se aprecia palidez, ictericia, vitiligo, edema de EEII, piel seca, con pelo quebradizo. En sus exámenes tiene hematocrito: 27%, con VCM: 110. **El diagnóstico más probable es:**

A Depresión

B Daño hepático crónico

C Déficit de vitamina B12

D Enfermedad de Addison

E Hipotiroidismo

Respuesta E. Bradicardia, piel seca, pelo quebradizo y edema: hipotiroidismo. La anemia macrocítica y el vitíligo apuntan a autoinmunidad asociada (anemia perniciosa), pero el cuadro global lo explica el hipotiroidismo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 36

Un paciente se realiza una tiroidectomía total hace varios años, por un carcinoma tiroideo. Suspende el tratamiento con levotiroxina hace 6 meses. **¿Qué alteración tendrá con mayor probabilidad en su examen físico?**

A Mixedema pretibial

B Exoftalmo

C Melanoplaquias

D Piel seca

E Acantosis nigricans

Respuesta D. Sin tiroides y sin levotiroxina, el paciente está hipotiroideo: piel seca. El mixedema pretibial y el exoftalmo son de la enfermedad de Graves; las melanoplaquias, del Addison; y la acantosis nigricans, de la resistencia a la insulina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 119

¿Cuál es la conducta más adecuada ante una paciente embarazada en el primer trimestre, que presenta una TSH de 4,5 UI/L? **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar propiltiouracilo

B Solicitar T4 libre

C Iniciar levotiroxina

D Solicitar una nueva TSH en un mes

E Solicitar cintigrafía tiroidea

Respuesta C. La meta de TSH en el primer trimestre es < 2,5. Con 4,5, sea hipotiroidismo clínico o subclínico gestacional, la conducta es tratar con levotiroxina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 173

Una paciente de 27 años consulta por un cuadro clínico de un año de evolución caracterizado por astenia, adinamia y malestar general. Además, ha aumentado 8 kg de peso y en el último mes presenta sensación de frío, constipación y mialgias. Al examen físico presenta lentitud en el lenguaje verbal y el razonamiento, piel seca y fría con vitíligo en la cara y manos, y alopecia moderada en el cuero cabelludo. Su frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto y su presión arterial de 130/80 mmHg. Se constata edema bilateral de extremidades inferiores, sin fóvea. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?**

A Hemograma - VHS

B Colonoscopía

C Niveles de cortisol

D TAC de cerebro

E TSH

Respuesta E. Aumento de peso, frío, constipación, bradipsiquia, piel seca, bradicardia y edema sin fóvea (mixedema), con vitíligo como marcador de autoinmunidad: hipotiroidismo, probablemente por tiroiditis de Hashimoto. El examen de elección para iniciar el estudio es la TSH, idealmente junto a la T4 libre.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 36

Un paciente se realizó una tiroidectomía total hace varios años, por un carcinoma tiroideo. Suspendió el tratamiento con levotiroxina hace 6 meses. **¿Qué alteración tendrá con mayor probabilidad en su examen físico?**

A Mixedema pretibial
B Exoftalmo
C Melanoplaquias
D Piel seca
E Acantosis nigricans

Respuesta D. Sin tiroides y sin levotiroxina desarrolla un hipotiroidismo, cuyo signo cutáneo típico es la piel seca, fría y áspera. El mixedema pretibial y el exoftalmo son propios de la enfermedad de Graves, las melanoplaquias de la enfermedad de Addison y la acantosis nigricans de la resistencia a la insulina.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 62 años, hipertensa controlada, con 6 meses de astenia, constipación y aumento de 4 kg. FC 54 lpm, piel seca y fría, relajación aquiliana prolongada y tiroides difusamente aumentada, firme e indolora. TSH 42,5 mUI/L, T4 libre 0,41 ng/dL, colesterol total 268 mg/dL y anti-TPO 650 UI/mL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Levotiroxina 1,6 mcg/kg/día y atorvastatina desde hoy
B Levotiroxina 50 mcg/día en ayunas y control de TSH en 6 a 8 semanas
C Repetir TSH y T4 libre en 3 meses antes de tratar
D Solicitar ecografía y punción tiroidea antes de tratar
E Levotiroxina 50 mcg/día y control de TSH en 2 semanas

Respuesta B. Hipotiroidismo primario clínico por Hashimoto (TSH > 10, T4L baja, bocio firme, anti-TPO alto). Por su edad se parte con 50 mcg/día en ayunas y se controla la TSH a las 6–8 semanas. La hipercolesterolemia es secundaria y se corrige con levotiroxina, sin estatinas de entrada.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Primigesta de 28 años, embarazo de 8 semanas confirmado por ecografía, en su primer control prenatal en el CESFAM. TSH 5,2 mUI/L con T4 libre 1,1 ng/dL (normal). Asintomática, PA 115/70 mmHg, examen segmentario normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Observar, porque la T4 libre es normal, y repetir la TSH en el tercer trimestre
B Iniciar levotiroxina 50 mcg/día y controlar TSH en 4 semanas
C Iniciar propiltiouracilo
D Solicitar ecografía tiroidea antes de decidir
E Iniciar levotiroxina después del primer trimestre para evitar teratogenia

Respuesta B. En el primer trimestre la meta es TSH < 2,5. Una TSH de 5,2 con T4L normal es un hipotiroidismo subclínico gestacional, que se trata: el cerebro fetal depende de la T4 materna en las primeras 12 semanas. Levotiroxina 50 mcg/día y TSH en 4 semanas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 105

Un paciente de 84 años se realiza una TSH, que resulta 8,4 UI/L. La TSH se repita 3 meses después, resultando 9,2 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Iniciar propiltiouracilo oral
B Iniciar levotiroxina oral 25 ug/día
C Iniciar tiamazol
D Iniciar corticoides orales
E Iniciar levotiroxina oral 75 ug/día

Respuesta B. Tiene un hipotiroidismo subclínico o clínico (no daban la T4 libre, por lo que no se puede saber). Sin embargo, de las opciones, la única que tenía sentido era iniciar levotiroxina y, por ser una adulto mayor, se debe iniciar con una dosis más baja.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 172

Una paciente de 27 años consulta por astenia, adinamia, malestar general de un año de evolución, aumento de 8 kg de peso, sensación de frío, constipación y mialgias. Al examen: lentitud en lenguaje y razonamiento, piel seca y fría, vitíligo en cara y manos, alopecia moderada, FC 60 lpm, PA 130/80 mmHg, edema bilateral de extremidades inferiores sin fóvea. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A Hemograma - VHS
B Colonoscopía
C Niveles de cortisol
D TAC de cerebro
E TSH

Respuesta E. Hipotiroidismo severo: En sospecha de hipotiroidismo, el examen inicial es la TSH (idealmente con T4 libre). El cuadro clínico con bradicardia, mixedema, piel seca, constipación, aumento de peso y lentitud psicomotora es altamente sugerente de hipotiroidismo severo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 136

Un paciente de 64 años consulta por astenia y mialgias de 3 meses de evolución. Se solicita TSH, que resulta 5,6 UI/L y T4 libre, que resulta 1,2 ug/ml (Valor Normal: 0,95 a 1,75 ug/ml). La conducta más adecuada es:

A Solicitar ecografía cervical

B Iniciar levotiroxina

C Solicitar TSH y T4 libre en 3 meses

D Indicar punción tiroidea

E Solicitar cintigrafía tiroidea

Respuesta C. Es una pregunta muy discutible, ya que el diagnóstico es un hipotiroidismo subclínico y el manejo de esta patología está llena de controversias. Los niveles de TSH y T4 libre de este paciente no justifican los síntomas. Lo más correcto sería seguir estudiando la causa de la astenia y mialgias. Dentro de las opciones, sería válida iniciar tratamiento, si la pregunta se refiere a un hipoT4 sintomático (y por lo tanto clínico), pero probablemente no se refiere a eso, por tener una TSH de apenas...

▶ VER CLASE 1.03.1.003 Hipertiroidismo

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 1.5 · Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio)
Endocrinología 7.6 · Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos
Endocrinología 7.7 · Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía
Endocrinología 7.8 · Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Clínica: baja de peso con apetito conservado, intolerancia al calor, temblor fino, taquicardia, palpitaciones, insomnio y polidefecación; en el adulto mayor puede ser apático (fibrilación auricular de novo, insuficiencia cardíaca).
- Diagnóstico: TSH suprimida (<0,01–0,1) con T4 libre alta; si la T4 libre es normal, medir T3 (T3-toxicosis). Graves: bocio difuso con soplo, orbitopatía y mixedema pretibial; TRAb positivos (especificidad >98 %) bastan para confirmarlo.
- Sin TRAb o sin signos típicos: cintigrama. Captación alta difusa (Graves), nódulo caliente (adenoma tóxico) o áreas calientes y frías (bocio multinodular tóxico); captación nula = tiroiditis o hormona exógena, donde los antitiroideos no sirven.
- Inicial: propranolol o atenolol para los síntomas y tiamazol 10–30 mg/día en una toma (PTU solo en el primer trimestre del embarazo y en tormenta); control de T4 libre a las 4–6 semanas.
- Fiebre u odinofagia con tionamidas: suspender y hemograma urgente (agranulocitosis). Seguimiento: derivar a endocrinología para tiamazol 12–18 meses o terapia definitiva (radioyodo, contraindicado en embarazo; cirugía si bocio >80 g, compresivo o sospecha de cáncer).

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 149

Mujer de 35 años con exoftalmo bilateral, palpitaciones, pérdida de peso y temblor fino en manos. TSH suprimida, T4 libre elevada. Bocio difuso. **¿Cuál es el diagnóstico?**

A Enfermedad de Graves-Basedow

B Tiroiditis de Hashimoto

C Bocio multinodular tóxico

D Adenoma tóxico de tiroides

E Tiroiditis subaguda de De Quervain

Respuesta A. Hipertiroidismo con bocio difuso y exoftalmo en una mujer joven: enfermedad de Graves-Basedow. La orbitopatía es patognomónica; el bocio multinodular y el adenoma tóxico son de adultos mayores y rara vez la tienen.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 35

Una paciente presenta un cuadro de 2 meses de evolución de sensación de calor mayor al habitual y sudoración. Se palpa su tiroides de tamaño normal y no presenta exoftalmo. Se solicitan pruebas tiroideas que demuestran TSH: 0,01 UI/L y T4 libre: 3,9 ng/ml. **¿Cuál es el examen de elección para determinar el diagnóstico etiológico?**

A Captación de yodo 131

B Ecografía de tiroides

C Punción aspirativa con aguja fina de tiroides

D Cintigrafía tiroidea

E Anticuerpos antitiroglobulina

Respuesta D. Hipertiroidismo sin bocio ni exoftalmo: la clínica no da la causa. El cintigrama tiroideo muestra el patrón de captación (difusa en Graves, nódulo caliente en el adenoma tóxico, áreas calientes y frías en el BMNT, nula en tiroiditis o facticia).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años con fibrilación auricular, usuario de amiodarona hace 2 años, sin bocio ni enfermedad tiroidea previa. Consulta por palpitaciones y baja de 4 kg. TSH 0,02 mUI/L, T4 libre 2,8 ng/dL. Eco-Doppler: tiroides de tamaño normal, sin vascularización. Captación de yodo nula. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A Tiamazol a dosis altas

B Prednisona 40 mg al día

C Radioyodo en dosis terapéutica

D Levotiroxina 50 µg al día

E Tiroidectomía total de urgencia

Respuesta B. Tiroides previamente normal, Doppler avascular y captación nula: tirotoxicosis por amiodarona tipo 2, una tiroiditis destructiva. Se trata con corticoides (prednisona 40 mg/día). El tiamazol a dosis altas es el tratamiento del tipo 1 (Jod-Basedow, con bocio previo y glándula hipervascular).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 30 años con enfermedad de Graves, en tratamiento con tiamazol 20 mg/día y propranolol hace 5 semanas. Consulta en urgencia por 1 día de fiebre de 39 °C y dolor faríngeo intenso. Faringe eritematosa con exudado amigdalino. FC 104 lpm. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Amoxicilina oral y control en 48 horas, manteniendo el tiamazol

B Cambiar el tiamazol por propiltiouracilo

C Suspender el tiamazol y solicitar hemograma urgente con recuento absoluto de neutrófilos

D Aumentar el tiamazol a 40 mg/día por probable descompensación

E Paracetamol y continuar el tratamiento sin cambios

Respuesta C. Fiebre y odinofagia en un paciente con tionamidas en los primeros 90 días: sospecha de agranulocitosis. Se suspende el fármaco de inmediato y se pide hemograma urgente; si el RAN es menor a 500/µL, hospitalización en aislamiento, antibióticos y G-CSF. No se cambia a PTU por reactividad cruzada.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 34 años con enfermedad de Graves que recae 6 meses después de completar 18 meses de tiamazol. No fuma y no tiene orbitopatía. Tiroides de 35 g sin nódulos. Planea su primer embarazo el próximo año. Se decide tratamiento con radioyodo. **¿Cuál es la indicación más importante asociada a esta terapia?**

A Prednisona profiláctica por 6 semanas

B Beta-hCG negativa antes de la dosis y anticoncepción eficaz por al menos 6 meses

C Solución de Lugol 7 a 10 días antes del radioyodo

D Suspender el radioyodo y reiniciar tiamazol hasta después del embarazo

E Evitar la levotiroxina después del tratamiento para no interferir con el embarazo

Respuesta B. Recidiva de Graves sin orbitopatía ni bocio compresivo: el radioyodo es una buena opción. Por el deseo de embarazo, lo fundamental es descartar embarazo actual (beta-hCG negativa) y asegurar anticoncepción al menos 6 meses después de la dosis. La prednisona profiláctica es para la orbitopatía activa; el Lugol es la preparación de la cirugía.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Paciente de 38 años con enfermedad de Graves y bocio difuso de 120 g con compresión traqueal sintomática, programado para tiroidectomía total. Está eutiroideo con tiamazol 20 mg/día. Se busca reducir la vascularización glandular y el sangrado operatorio. **¿Cuál es la medida farmacológica recomendada en los 7 a 10 días previos a la cirugía?**

A Solución de Lugol oral, 3 a 5 gotas cada 8 horas

B Suspender el tiamazol e iniciar propiltiouracilo a dosis altas

C Una dosis baja de radioyodo 48 horas antes de la incisión

D Anticoagulación plena con heparina de bajo peso molecular

E Carbonato de litio para aumentar la captación de hormonas

Respuesta A. La solución de Lugol (o SSKI) 7 a 10 días antes de la tiroidectomía produce el efecto Wolff-Chaikoff transitorio y disminuye el flujo sanguíneo glandular, reduciendo el riesgo de tormenta y de hemorragia intraoperatoria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 145

Era una clínica de ojo rojo, pero con temblor en las manos y baja de peso, al examen físico se observa retracción palpebral: a. TSH y T4 libre

A Accidente cerebrovascular

B Epilepsia

C Esclerosis múltiple

D Enfermedad de Parkinson

E Migraña

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Accidente cerebrovascular). Los trastornos ansiosos incluyen el trastorno de pánico (o angustia), el trastorno de ansiedad generalizada, la agorafobia, la fobia social, las fobias simples, el TOC, el trastorno de estrés postraumático (TEPT), el estrés agudo y el trastorno adaptativo.

▶ VER CLASE 1.03.1.004 Cáncer del tiroides

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.10 · Cáncer de Tiroides: Subtipos Histológicos y Manejo Oncológico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante nódulo tiroideo con factores de riesgo: radioterapia cervical en la infancia, familiar con carcinoma medular o NEM 2, crecimiento rápido, disfonía (parálisis de cuerda vocal), nódulo duro o adenopatías cervicales duras y fijas.
- Papilar (85–90 %, diseminación linfática, excelente pronóstico) y folicular (5–10 %, hematógena a pulmón y hueso, la PAAF no lo diagnostica) son los diferenciados; medular (células C, calcitonina y CEA, 25 % hereditario por RET); anaplásico (adulto mayor, masa pétrea que crece en semanas con disfonía, disfagia y estridor).
- Estudio inicial: TSH y ecografía cervical (nódulo y ganglios), PAAF guiada según TI-RADS; Bethesda IV, V o VI obligan a derivar.
- Tratamiento por especialista: tiroidectomía total (o lobectomía en papilar unifocal de bajo riesgo), radioyodo según riesgo y levotiroxina con TSH frenada; en el medular descartar feocromocitoma antes de operar.
- GES cáncer de tiroides diferenciado y medular desde los 15 años. Seguimiento: derivar; luego levotiroxina de por vida y control con tiroglobulina + anti-Tg (diferenciado) o calcitonina (medular) y ecografía de cuello.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 74 años consulta por una masa cervical anterior que notó hace 4 semanas y que ha crecido rápidamente. Refiere disfonía, dificultad para tragar y en las últimas horas ruido al respirar. Al examen se palpa una masa tiroidea de 6 cm, pétrea, fija a planos profundos, con estridor inspiratorio. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Carcinoma papilar de tiroides

B Carcinoma folicular de tiroides

C Carcinoma anaplásico de tiroides

D Bocio multinodular

E Tiroiditis subaguda de De Quervain

Respuesta C. Adulta mayor con masa pétrea y fija que crece en semanas e invade nervio recurrente, esófago y tráquea (disfonía, disfagia, estridor): carcinoma anaplásico, 1–2 % de los casos, con sobrevida media de 3 a 6 meses. El papilar y el folicular crecen lento y afectan a pacientes más jóvenes.

▶ VER CLASE 1.03.1.005 Tiroiditis

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 1.5 · Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio)

QUÉ HAY QUE SABER

- De Quervain (subaguda): 1–3 semanas tras una infección respiratoria; dolor cervical intenso irradiado a mandíbula y oídos, tiroides dolorosa, VHS >60–100 mm/h y captación de yodo casi nula (<1–2 %).
- Evolución de las destructivas en tres fases: tirotóxica (semanas 1–6), hipotiroidea (6–16) y recuperación en más del 90 % a los 4–6 meses.
- Tratamiento de De Quervain: AINE (ibuprofeno o naproxeno); prednisona 30–40 mg/día con descenso en 4–6 semanas si es refractaria; propranolol para palpitaciones y temblor. El tiamazol no sirve (no hay síntesis).
- Silente o posparto: indolora, anti-TPO positivos en 50–70 %; propranolol en la fase tóxica y levotiroxina transitoria si hay hipotiroidismo sintomático. Hashimoto: bocio firme indoloro, levotiroxina de por vida según TSH. Supurada: fluctuación y leucocitosis, drenaje y antibióticos EV.
- Amiodarona tipo 1 (bocio previo, Doppler vascular): tiamazol; tipo 2 destructiva (captación nula): prednisona 40 mg/día. Litio: mantenerlo y agregar levotiroxina. Seguimiento: TSH seriada hasta la recuperación y luego anual en las posparto (riesgo de hipotiroidismo definitivo).

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 30

Una paciente de 23 años, consulta por malestar general y sensación febril de una semana de evolución, asociado a artralgias y palpitaciones. Al examen físico destaca glándula tiroides del doble del tamaño normal, muy dolorosa a la palpación, frecuencia cardiaca de 90 latidos por minuto y presión arterial de 120/80 mm Hg. Se solicitan exámenes que muestran TSH: 0,01 UI/L (valor normal: 0,3-4,5 UI/L), T4L: 1,9 ng/mL (valor normal: 0,6-1,7 ng/mL), captación de yodo radioactivo de 2% (valor normal: 20% a 30%). **¿Cuál es el tratamiento de elección en esta paciente?**

A Tiamazol

B AINEs

C Propiltiouracilo

D Bloqueadores beta

E Yodo radioactivo en dosis terapéutica

Respuesta B. Tiroides dolorosa, febrícula, tirotoxicosis y captación del 2 %: tiroiditis subaguda de De Quervain. Se trata con AINE. Los antitiroideos no sirven y el radioyodo no capta. El betabloqueo alivia los síntomas, pero no es el tratamiento de la enfermedad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 10

Una paciente de 33 años, consulta por dolor cervical intenso de una semana de evolución asociado a sensación febril. Al examen físico destaca glándula tiroides del doble del tamaño normal, muy dolorosa a la palpación, frecuencia cardiaca de 90 latidos por minuto y presión arterial de 120/80 mm Hg. Se solicitan exámenes que muestran TSH: 0,2 UI/L, T4L: 1,9 ng/mL (Valor normal: 0,6-1,7 ng/mL), captación de yodo radioactivo de 2% (Valor normal: mayor a 3%). **¿Cuál es el tratamiento de elección en esta paciente?**

A Propiltiouracilo
B Ibuprofeno
C Prednisona
D Levotiroxina
E Yodo radioactivo

Respuesta B. Tiroiditis subaguda de De Quervain: la primera línea es un AINE como el ibuprofeno. La prednisona se reserva para el dolor muy intenso o refractario a AINE. No se usan antitiroideos ni radioyodo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 114

Una paciente de 30 años, usuaria de anticonceptivos orales, consulta por cuadro de 8 días de sudoración, palpitaciones e insomnio, que durante los últimos días se ha asociado a dolor en región cervical anterior. Al examen físico se aprecia con frecuencia cardiaca de 100 por minuto, presión arterial 140/90, dolor a la palpación cervical. Se solicitan exámenes donde destaca T4 y T4L aumentadas y TSH suprimida, electrocardiograma normal. **El tratamiento de elección en este caso es:**

A Propiltiouracilo
B Paracetamol
C Metimazol
D Ketoprofeno
E Enalapril

Respuesta D. Tirotoxicosis con dolor cervical anterior: tiroiditis subaguda de De Quervain. Se trata con un AINE (ketoprofeno). El paracetamol no tiene efecto antiinflamatorio suficiente y los antitiroideos no están indicados.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 115

Una paciente usuaria de anticonceptivos y con antecedentes familiares de hipotiroidismo, consulta por aumento de volumen en el cuello. Al examen físico, la tiroides se palpa aumentada de tamaño, sin nódulos. Los exámenes revelan una TSH: 2,0 UI/L, T4: 14,0 ug/dl (valor normal: 4,5 a 9,5), anticuerpos antitiroglobulina: 48 UI/ml (valor normal: <35) y anticuerpos antiperoxidasa tiroidea: 320 UI/ml (valor normal: <35). **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar T4 libre
B Solicitar ecografía tiroidea
C Solicitar una cintigrafía tiroidea
D Realizar control de TSH y T4 en un año
E Realizar biopsia tiroidea por punción

Respuesta D. Bocio difuso con antiperoxidasa muy elevados y TSH normal: tiroiditis de Hashimoto eutiroidea. La T4 total alta se explica por los anticonceptivos, que elevan la proteína transportadora; la TSH normal descarta hipertiroidismo. Se controla la función tiroidea en forma anual para pesquisar el hipotiroidismo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 160

Una paciente consulta por un cuadro de 3 semanas de evolución de fiebre, sudoración nocturna, temblor, malestar general y artralgias. Hace 7 días se agrega dolor en el cuello. Al examen físico tiene marcado dolor a la palpación de la glándula tiroides. Se solicitan exámenes que muestran TSH: 0,01 UI/L y T4 libre: 2,9 ng/dl, con captación de yodo radiactivo de 1% (VN: 2 a 40%). El tratamiento más adecuado es:

A Paracetamol
B Antibióticos
C Prednisona
D Metimazol
E Ketoprofeno

Respuesta E. Tiene una clásica tiroiditis subaguda o tiroiditis de Quervain, que se trata con AINEs. Solo si es que tiene muchos síntomas hipertiroideos se agrega el propanolol. No están indicadas las drogas antitiroideas (metimazol o propiltiouracilo).

▶ VER CLASE **1.03.1.006** **Síndrome de Cushing** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.11 · Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico

QUÉ HAY QUE SABER

- Causa más frecuente: exógena (corticoides orales, inyectables, tópicos o inhalados). Endógena ACTH-dependiente 80–85 % (enfermedad de Cushing por microadenoma hipofisario 70–75 %, ACTH ectópica 10 %) o independiente (adenoma suprarrenal 10 %, carcinoma).
- Signos más específicos: equimosis fáciles, estrías violáceas anchas (>1 cm), miopatía proximal y plétora facial; acompañan obesidad central, cara de luna, giba, HTA resistente, diabetes, osteoporosis e hirsutismo.
- Tamizaje (descartada causa exógena y pseudo-Cushing por depresión, alcohol u obesidad mórbida): test de Nugent (dexametasona 1 mg a las 23 h, cortisol 8 h normal <1,8 mcg/dL), cortisol libre urinario de 24 h o cortisol salival nocturno; se confirma con 2 pruebas alteradas. El cortisol matinal aislado no sirve.

- Recién confirmado: ACTH plasmática; suprimida, TC de suprarrenales; normal o alta, RM de silla turca. ACTH ectópica: cuadro fulminante con hipokalemia, hiperpigmentación y ACTH >100 en fumador.
- No es GES: derivar con prioridad a endocrinología (cirugía transesfenoidal o suprarrenalectomía, luego hidrocortisona por 6–12 meses). Inicial: controlar HTA, diabetes e hipokalemia, prevenir trombosis e infecciones.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 27

Una paciente de 13 años, sin antecedentes, consulta por cefalea e hirsutismo. Al examen físico se encuentra presión arterial en percentil 99 para su edad, índice de masa corporal mayor al percentil 95 para su edad, acné inflamatorio en su rostro y estrías abdominales. **El diagnóstico más probable es:**

A Diabetes mellitus tipo 2
B Síndrome de ovario poliquístico
C Síndrome de Cushing
D Hipotiroidismo
E Hiperprolactinemia

Respuesta C. Obesidad, hipertensión marcada, estrías, hirsutismo y acné: el conjunto corresponde a un síndrome de Cushing. El ovario poliquístico explica el hirsutismo y el acné, pero no la hipertensión severa con estrías.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 169

Una mujer de 34 años, con amenorrea de 6 meses, presenta un cuadro de astenia y malestar general. Además refiere equimosis ante mínimos traumatismos. Actualmente tiene PA: 150/90 mmHg, acné facial, cuello ancho, obesidad centrípeta y estrías violáceas. Tiene prueba de embarazo negativa. **¿Cuál es la prueba a realizar en primer lugar?**

A Cortisol plasmático basal
B FSH y estradiol plasmático
C Cortisol libre urinario
D Prueba de estimulación con ACTH
E Resonancia magnética de silla turca

Respuesta C. Equimosis fáciles, estrías violáceas, obesidad centrípeta e hipertensión: sospecha de Cushing. El estudio parte con una prueba de primera línea, como el cortisol libre urinario de 24 horas. El cortisol basal no sirve, la estimulación con ACTH es para la insuficiencia suprarrenal y la resonancia va después.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 159

Una paciente de 29 años consulta por aumento de peso de 10 kg en un año, a pesar de seguir una dieta. Refiere también que sus reglas se han vuelto irregulares y cada vez son menos frecuentes. En su examen físico se observa obesidad y estrías en el abdomen y los muslos, de color rojizo. Sus signos vitales muestran FC: 72 lpm y PA: 150/96 mmHg. **¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para iniciar el estudio de esta paciente?**

A Cortisol plasmático a las 7:00 y a las 23:00 horas
B Cortisol plasmático post-dexametasona
C Niveles plasmáticos de ACTH
D Resonancia magnética nuclear de abdomen
E Resonancia magnética nuclear de hipófisis

Respuesta B. El estudio del Cushing se inicia con una prueba de primera línea: cortisol libre urinario, test de supresión con 1 mg de dexametasona o cortisol salival. La ACTH y las imágenes van después de confirmar el hipercortisolismo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 41 años, sin uso de corticoides, con obesidad central, estrías violáceas de 1,5 cm y miopatía proximal. Test de Nugent: cortisol 8 h de 12 mcg/dL. Cortisol libre urinario de 24 h: 5 veces el límite superior. ACTH plasmática matinal: indetectable (menor de 2 pg/mL). **¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?**

A Resonancia magnética de silla turca con gadolinio
B Tomografía computarizada de abdomen con protocolo suprarrenal
C Cateterismo de senos petrosos inferiores
D Test de estimulación con ACTH sintética
E Tomografía computarizada de tórax

Respuesta B. El hipercortisolismo está confirmado con dos pruebas de primera línea alteradas. La ACTH suprimida indica un Cushing ACTH-independiente: el origen es suprarrenal, y la imagen que corresponde es la TC de abdomen con protocolo suprarrenal. La RM de silla turca y el cateterismo se reservan para el Cushing ACTH-dependiente.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 62 años, fumador pesado de 40 paquetes/año, consulta por astenia severa, debilidad muscular profunda, edema de extremidades inferiores y pérdida de 8 kg de peso en el último mes. Destaca hiperpigmentación cutánea difusa, PA 175/105 mmHg, sin obesidad evidente. Glicemia 260 mg/dL, potasio 2,1 mEq/L y bicarbonato 36 mEq/L. Se confirma hipercortisolismo con ACTH plasmática de 280 pg/mL. El test con dexametasona 8 mg no suprime el cortisol. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Enfermedad de Cushing por adenoma hipofisario

B Carcinoma de la corteza suprarrenal productor de cortisol

C Síndrome de Cushing ectópico secundario a carcinoma pulmonar de células pequeñas (oat cell)

D Hiperaldosteronismo primario (Síndrome de Conn)

E Insuficiencia suprarrenal primaria por metástasis

Respuesta C. ACTH muy elevada que no suprime con 8 mg de dexametasona, en un fumador con cuadro rápido, hipokalemia con alcalosis metabólica e hiperpigmentación: Cushing ectópico por carcinoma pulmonar de células pequeñas. La rapidez explica que no alcance el fenotipo cushingoide.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una paciente de 41 años con Síndrome de Cushing confirmado presenta una ACTH plasmática indetectable (< 2 pg/mL). La TC de abdomen revela un tumor suprarrenal derecho de 3.2 cm homogéneo con baja atenuación (< 10 Unidades Hounsfield) compatible con adenoma benigno; la glándula suprarrenal izquierda luce de aspecto atrófico y delgada. La paciente es sometida exitosamente a una suprarrenalectomía laparoscópica derecha. **En el postoperatorio inmediato, ¿cuál es la medida farmacológica mandatoria que debe iniciarse para prevenir una complicación potencialmente mortal?**

A Iniciar ketoconazol oral para bloquear residuos tumorales

B Iniciar terapia de reemplazo hormonal con Hidrocortisona por riesgo inminente de crisis suprarrenal secundaria a la atrofia del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal contralateral

C Indicar espironolactona a dosis altas para prevenir hiperkalemia

D Indicar radioyodo I-131 para destruir remanentes glandulares

E Mantener en observación sin medicamentos puesto que la glándula contralateral asumirá de inmediato la función fisiológica

Respuesta B. El cortisol autónomo del adenoma suprimió por años la ACTH, y la suprarrenal contralateral está atrófica. Al extirpar el adenoma, la paciente cae en insuficiencia suprarrenal aguda: se inicia hidrocortisona de inmediato y se mantiene 6 a 12 meses, hasta que el eje se recupere.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 18

Una paciente de 28 años aumento de peso de 5 meses de evolución, asociado a malestar general. Refiere importante astenia, que ha progresado y debilidad muscular. Al examen físico presenta PA: 150/100 mmHg, atrofia de las masas musculares de las extremidades, obesidad abdominal y piel con estrías vinosas en la pared abdominal e hirsutismo en cara, abdomen y pecho. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?

A Niveles de ACTH plasmático matinal y vespertino

B 17 hidroxiprogesterona

C TAC de silla turca

D Cortisol libre urinario de 24 horas

E Prueba de estimulación con ACTH

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Cortisol libre urinario de 24 horas). El síndrome de Cushing se estudia de elección con el cortisol libre urinario de 24 horas. El hipotiroidismo en el embarazo es importante porque se asocia a daño en el desarrollo cerebral del feto.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 43

Una paciente de 16 años, obesa, consulta por astenia y debilidad de semanas de evolución, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se corrobora obesidad en percentil 97 para la edad, se aprecia hirsutismo, acné inflamatorio y estrías abdominales. El diagnóstico más probable es:

A Resistencia insulínica

B Síndrome de ovario poliquístico

C Síndrome de Cushing

D Diabetes Mellitus tipo 1

E Hiperprolactinoma

Respuesta C. Diagnóstico: Síndrome de Cushing (opción C). Es la misma pregunta de antes. El hipotiroidismo en el embarazo es importante porque se asocia a daño en el desarrollo cerebral del feto.

▶ VER CLASE 1.03.1.007 Insuficiencia suprarrenal crónica

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.12 · Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Primaria (Addison): destrucción de la corteza, autoinmune en 70–80 % (también TBC, metástasis, hemorragia); falta cortisol y aldosterona, con ACTH muy alta, hiperpigmentación (pliegues palmares, mucosa oral, cicatrices) e hiperkalemia.
- Secundaria: falta de ACTH; la causa más frecuente es la suspensión brusca de corticoides (también tumores selares, apoplejía, radioterapia); piel pálida y potasio normal.
- Sospecha: astenia, baja de peso, náuseas, hipotensión ortostática, hipoglicemia e hiponatremia de meses de evolución.

- Confirmación: cortisol plasmático a las 8 h <3 mcg/dL confirma, >15–18 lo descarta; entre 3 y 15, test de Synacthen 250 mcg (pico <18 confirma). La ACTH separa primaria (alta) de secundaria (baja).
- Inicial: hidrocortisona 15–25 mg/día en 2–3 tomas (10–5–2,5 mg) y, solo en Addison, fludrocortisona 0,05–0,1 mg/día; educar: duplicar o triplicar dosis ante fiebre o infección y hidrocortisona 100 mg IM si hay vómitos. Seguimiento: derivar a endocrinología; ajustar por clínica, PA y electrolitos, nunca por cortisol.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 112

Un paciente alcohólico, vagabundo, con antecedente de haber sido tratado por tuberculosis hace dos años, consulta por un cuadro de diarrea y baja de peso, malestar general de algunos meses de evolución. En su examen físico se aprecia IMC de 16, hiperpigmentación de pliegues y melanoplaquias. En sus exámenes tiene K: 5,5 mEq/L, Na: 132 mEq/L. **El diagnóstico más probable es:**

A Síndrome paraneoplásico
B Desnutrición proteica
C Enfermedad de Addison
D Cáncer de sitio no precisado
E Pancreatitis crónica

Respuesta C. Hiperpigmentación de pliegues, melanoplaquias, hiperkalemia e hiponatremia: insuficiencia suprarrenal primaria, probablemente por tuberculosis suprarrenal, que es la segunda causa después de la autoinmune.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 102

Un paciente alcohólico, en situación de calle, con antecedente de una tuberculosis tratada hace 2 años, consulta por astenia de 3 meses de evolución, asociada a debilidad muscular, dolor abdominal y diarrea. Al examen físico tiene FC 110 lpm, PA 90/60 mmHg y presenta hiperpigmentación en los pliegues y melanoplaquias. Entre sus exámenes destaca creatinina 1,0 mg/dl, sodio 131 mEq/L, potasio 5,6 mEq/L, cloro 94 mEq/L, hematocrito 35% y blancos 7.500 por mm³. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Síndrome paraneoplásico
B Cáncer de origen desconocido
C Enfermedad de Addison
D Daño hepático crónico
E Tuberculosis renal

Respuesta C. Astenia, hipotensión, síntomas digestivos, hiperpigmentación de pliegues y mucosas, hiponatremia e hiperkalemia: insuficiencia suprarrenal primaria (Addison). El antecedente de tuberculosis apunta a la segunda causa más frecuente, después de la autoinmune. La hiperpigmentación se debe a la ACTH elevada.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 42 años acude por debilidad marcada, náuseas recurrentes, baja de 6 kg de peso e hipotensión arterial. Destaca hiperpigmentación marcada en surcos de las manos, codos y encías. Na 129 mEq/L, K 5,8 mEq/L y glicemia 70 mg/dL. Cortisol basal 8 h: 2,0 mcg/dL con ACTH plasmática de 180 pg/mL (VN < 50). **¿Cuál es el tratamiento sustitutivo crónico de elección que debe prescribirse?**

A Hidrocortisona oral en monoterapia
B Prednisona oral asociada a espironolactona
C Hidrocortisona oral asociada obligatoriamente a Fludrocortisona oral
D Dexametasona oral en dosis nocturna única
E Fludrocortisona oral en monoterapia sin glucocorticoides

Respuesta C. Cortisol menor de 3 mcg/dL con ACTH elevada, hiperpigmentación e hiperkalemia: enfermedad de Addison. Falta cortisol y aldosterona, así que el reemplazo es hidrocortisona 15–25 mg/día repartida más fludrocortisona 0,05–0,1 mg/día.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 58 años con artritis reumatoide, en tratamiento con prednisona 15 mg diarios durante 2 años, suspende bruscamente el fármaco. A los 5 días consulta por debilidad extrema, náuseas, astenia e hipotensión postural (PA 95/60 mmHg). Piel pálida sin hiperpigmentación. Na 131 mEq/L, K 4,2 mEq/L, ACTH 4 pg/mL y cortisol 2,1 mcg/dL. **¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal que explica este cuadro?**

A Destrucción autoinmune aguda de la glándula suprarrenal
B Supresión exógena prolongada del eje hipotálamo-hipófisis con atrofia corticosuprarrenal secundaria y déficit exclusivo de glucocorticoides con aldosterona preservada
C Falla mineralocorticoide primaria con pérdida renal masiva de potasio
D Secreción ectópica de péptidos supresores adrenales
E Síndrome de lisis corticosuprarrenal por nefropatía intersticial

Respuesta B. El corticoide exógeno por años frenó la CRH y la ACTH (ACTH de 4 pg/mL) y atrofió la corteza. Al suspenderlo, falta cortisol, pero la glomerulosa depende del sistema renina-angiotensina: la aldosterona está preservada, por eso el potasio es normal y no hay hiperpigmentación.

▶ VER CLASE 1.03.1.008 **Hirsutismo** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.2 · Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Hirsutismo: vello terminal de distribución masculina en la mujer (Ferriman-Gallwey ≥8); la causa más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico (SOP), seguido del hirsutismo idiopático.
- SOP por criterios de Rotterdam (2 de 3): oligo o anovulación (ciclos >35 días), hiperandrogenismo clínico o bioquímico y morfología poliquística en la ecografía; se asocia a resistencia a la insulina.
- Descarte obligatorio: 17-hidroxiprogesterona (hiperplasia suprarrenal no clásica), TSH y prolactina. Banderas rojas de tumor productor de andrógenos o Cushing: virilización (clitoromegalia, voz grave, calvicie), inicio rápido, testosterona o DHEA-S muy elevadas.
- Inicial: estilo de vida (bajar 5–10 % del peso restablece la ovulación en más de la mitad); sin deseo de embarazo, anticonceptivos combinados con progestágeno antiandrogénico (ciproterona, dienogest o drospirenona), metformina si hay resistencia a la insulina y espironolactona si persiste el hirsutismo; medidas cosméticas.
- Seguimiento completo por el médico general: respuesta a 6 meses de tratamiento, control metabólico (glicemia, lípidos) y protección endometrial en la anovulación crónica; con deseo de embarazo, letrozol (derivar). Derivar si hay virilización o sospecha de tumor.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 115

Una paciente de 17 años, con menarquia a los 16 años, tiene reglas cada 3 a 4 meses. Presenta vello grueso en el mentón, los brazos, el pecho, los muslos y la línea media abdominal, tanto infraumbilical como supraumbilical, con un índice de Ferriman-Gallwey mayor a 15. Su examen mamario y genital son normales. **¿Cuál es el examen de elección para hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de ovario poliquístico?**

A Relación FSH sobre LH
B Cariograma
C Curva de insulina
D Niveles plasmáticos de prolactina
E Diecisiete hidroxiprogesterona

Respuesta E. El cuadro es compatible con hiperandrogenismo severo, y el diagnóstico diferencial obligatorio del ovario poliquístico es la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, que se descarta midiendo la 17-hidroxiprogesterona.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 110

Una paciente de 17 años, con antecedente se haber tenido su menarquia a los 16 años, con reglas que ocurren cada 3 a 4 meses. Tiene hirsutismo en el mentón, los brazos, el pecho, los muslos y la línea media abdominal, tanto infraumbilical, como supraumbilical, con un índice de Ferriman-Gallwey > 15. ¿Cuál es el examen de elección para hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de ovario poliquístico?

A Relación FSH/LH
B Cariograma
C Curva de insulina
D Prolactina
E 17-hidroxi-progesterona

Respuesta E. [Pregunta disputada] No se entiende qué es lo que se quería pregunta. La 17-OH progesterona permite diagnosticar la hiperplasia suprarrenal congénita, que es el diagnóstico diferencial del SOP más importante y que también tiene mucho hirsutismo. Por otro lado, la relación LH/FSH elevada sugiere un SOP, aunque no se usa como criterio, por tener muchos falsos negativos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 115

Una paciente de 17 años, con IMC de 34, presenta oligomenorrea, desde su primera mesntruación. Además tiene acné y se observa hirsutismo en la cara, los pezones e intermamario. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A Testosterona plasmática
B Andrógenos totales
C Prueba de progesterona
D Índice de andrógenos libres
E 17 hidroxiprogesterona

Respuesta D. Tiene un SOP ya diagnosticado (cumple 2 criterios: oligomenorrea y el hiperandrogenismo cínico), por tanto no es necesario pedir ningún examen. No aparecía como alternativa, así que hay que pedir índice de andrógenos libres, que es el examen de eleción para evaluar el hiperandrogenismo en el SOP).

▶ VER CLASE 1.03.1.009 Hipertensión arterial de origen endocrino

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 7.14 · Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria
Endocrinología 7.15 · Feocromocitoma y Paragangliomas: Bloqueo Alfa Obligatorio

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar HTA endocrina en: HTA resistente (3 fármacos incluido diurético), HTA con hipokalemia, inicio antes de los 35–40 años, crisis paroxísticas, incidentaloma suprarrenal o fenotipo cushingoide.
- Hiperaldosteronismo primario: HTA con hipokalemia y alcalosis; tamizaje con relación aldosterona/renina (RAR >20–30 con aldosterona >15, corrigiendo antes el potasio y suspendiendo espironolactona); se confirma con sobrecarga salina y luego TC.
- Feocromocitoma: crisis de cefalea, sudoración y palpitaciones con HTA; examen de elección: metanefrinas plasmáticas o urinarias de 24 h, luego imagen. Nunca betabloqueo antes del bloqueo alfa.
- Otras: Cushing (Nugent o cortisol libre urinario), hipertiroidismo (TSH), hiperparatiroidismo (calcemia) y acromegalia.

- Inicial: controlar la PA (espironolactona en hiperaldosteronismo; doxazosina o fenoxibenzamina en feocromocitoma). Derivar a endocrinología: adenoma de Conn unilateral y feocromocitoma se operan; la hiperplasia bilateral se trata con espironolactona o eplerenona de por vida.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 45

Una paciente de 60 años presenta cefalea, astenia, debilidad muscular y calambres en extremidades inferiores. Al examen físico se observa obeso, con PA: 170/100 mmHg, FC: 70 lpm y en sus exámenes destaca Na: 150 mEq/L, K: 2.6 mEq/L, Cl:100 mEq/L y TSH: 4.0 UI/L. **La causa más probable de la hipertensión es:**

A Hipertensión renovascular
B Feocromocitoma
C Hipotiroidismo
D Hiperaldosteronismo primario
E Hipertensión esencial

Respuesta D. Hipertensión con hipokalemia marcada y síntomas de hipokalemia (calambres, debilidad, cefalea): hiperaldosteronismo primario clásico. La renovascular también puede dar hipokalemia por hiperaldosteronismo secundario, pero se sospecha con soplo abdominal o antecedente cardiovascular.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 121

Un paciente de 37 años es diagnosticado de hipertensión hace un año, en tratamiento con enalapril, atenolol e hidroclorotiazida, a pesar de lo cual ha presentado valores tensionales sobre el objetivo, con varias tomas sobre 160/110 mmHg. Además, aqueja astenia, debilidad de las extremidades inferiores y cefalea frecuente. Se solicitan exámenes generales, que muestran TSH: 6,0 UI/L, creatinina: 1,2 mg/dl, sodio: 142 mEq/L, potasio: 3,1 mEq/L, hemograma normal y glicemia de ayuno: 72 mg/dl. Se solicita TAC de abdomen, que muestra un tumor suprarrenal derecho, de 2 cm de diámetro, sólido y homogéneo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Feocromocitoma
B Hipertensión esencial
C Hipertensión renovascular
D Hipertensión asociada a insuficiencia renal
E Hiperaldosteronismo primario

Respuesta E. Joven, HTA resistente a tres fármacos con diurético, hipokalemia con síntomas y un nódulo suprarrenal pequeño y homogéneo: adenoma productor de aldosterona (Conn). El feocromocitoma daría crisis paroxísticas, no hipokalemia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 82

Paciente con HTA de difícil control, cefalea, palpitaciones y lesión suprarrenal derecha de 5 cm en TAC. **¿Diagnóstico más probable?**

A Adenoma suprarrenal productor de aldosterona
B Carcinoma suprarrenal
C Feocromocitoma
D Quiste suprarrenal simple
E Hiperplasia suprarrenal nodular

Respuesta C. HTA de difícil control con cefalea y palpitaciones (clínica adrenérgica) y una masa suprarrenal grande: feocromocitoma. El adenoma de Conn da HTA con hipokalemia, sin crisis adrenérgicas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 59

Una paciente de 60 años presenta cefalea, astenia y calambres en extremidades inferiores. Al examen físico destaca PA: 170/95 mmHg, FC: 80 lpm y en sus exámenes destaca Na: 150 mEq/L, K: 2.6 mEq/L, Cl: 90 mEq/L y TSH: 4.0 UI/L. **La causa más probable de la hipertensión es:**

A Hipertensión renovascular
B Feocromocitoma
C Hipotiroidismo
D Hiperaldosteronismo
E Hipertensión esencial

Respuesta D. La HTA renovascular también puede dar hipokalemia (hiperaldosteronismo secundario), pero aquí no hay soplo ni alza de creatinina; la hipokalemia marcada con calambres, astenia y sodio alto calza mejor con hiperaldosteronismo primario.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 52 años con hiperaldosteronismo primario confirmado por RAR elevada y test de sobrecarga salina. La TC muestra hiperplasia suprarrenal bilateral. Inició espironolactona 50 mg/día con buen control de presión y potasio normal, pero a los 4 meses consulta por aumento de volumen mamario doloroso bilateral. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Suprarrenalectomía laparoscópica bilateral
B Cambiar espironolactona por eplerenona
C Aumentar espironolactona a 100 mg/día
D Suspender espironolactona e indicar hidroclorotiazida
E Solicitar muestreo venoso suprarrenal

Respuesta B. La hiperplasia bilateral se trata de por vida con un antagonista mineralocorticoide. La ginecomastia es el efecto antiandrogénico de la espironolactona: se rota a eplerenona, selectiva. La cirugía bilateral dejaría una insuficiencia suprarrenal permanente, y una tiazida empeoraría la hipokalemia.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 36 años con episodios de cefalea pulsátil intensa, palpitaciones y sudoración profusa de 15 a 30 minutos, 2 a 3 veces por semana desde hace 3 meses. En una crisis en el policlínico se constata PA 210/120 mmHg y FC 130 lpm. Entre las crisis está asintomática. **¿Cuál es el examen inicial más adecuado para confirmar la sospecha?**

A TC de abdomen con contraste

B Catecolaminas plasmáticas durante una crisis

C Metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas

D Relación aldosterona / renina plasmática

E Cintigrafía con MIBG

Respuesta C. Tríada paroxística con HTA: sospecha de feocromocitoma. El examen de primera línea son las metanefrinas (plasmáticas o urinarias de 24 h), con sensibilidad > 98 %. La TC y la MIBG localizan, pero solo después de confirmar; las catecolaminas son menos sensibles; la RAR estudia el hiperaldosteronismo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 32

Un paciente de 35 años consulta por cefalea y debilidad muscular de algunos meses de evolución. Al examen físico presenta FC: 70x', PA: 160/110 mmHg, sin otros hallazgos. Se solicitan exámenes que muestran creatininemia de 0,9 mg/dl, sodio: 138 mEq/l, potasio: 3,0 mEq/l y cloro: 98 mEq/l. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio en este paciente?

A Doppler de arterias renales

B Holter de presión arterial

C Determinación de metanefrinas urinarias

D Relación aldosterona / actividad de renina plasmática

E Cortisol libre urinario de 24 horas

Respuesta D. Un paciente joven con hipertensión y cefalea, con hipopotasemia y debilidad muscular, tiene una hipertensión secundaria con sospecha de hiperaldosteronismo primario. El estudio de elección es la relación aldosterona/actividad de renina plasmática. Las metanefrinas se piden ante crisis adrenérgicas y el cortisol libre ante rasgos cushingoides, y el Doppler renal se reserva para sospecha de hipertensión renovascular.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 59

Hipertensión renovascular (yo vi 2 hiperaldosteronismos primarios, confirmo x2) habían 2, uno joven con muchos sintomas de hipokalemia (HAP)y la otra era adulto mayor con proteinuria (HTRV)? vs Hiperaldosteronismo primario

A Ninguna de las anteriores es correcta

B Todas las anteriores son correctas

C No se dispone de información suficiente

D Otra alternativa no descrita

E Otra alternativa no descrita

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Ninguna de las anteriores es correcta). Clase sobre diagnóstico, objetivos y pilares del tratamiento de la hipertensión arterial.

▶ VER CLASE 1.03.1.010 Amenorrea

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.1 · Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

QUÉ HAY QUE SABER

- Amenorrea secundaria: ausencia de regla por 3 meses (o 6 si era irregular). El primer examen siempre es la beta-hCG (embarazo, la causa más frecuente); luego TSH y prolactina.
- Test de progesterona: si sangra hay estrógenos sin ovulación (anovulación, SOP); si no sangra, test de estrógeno + progesterona y FSH: FSH alta = falla ovárica (insuficiencia ovárica prematura si <40 años); FSH baja = hipotalámica o hipofisaria; sin sangrado con estrógenos tras legrado = Asherman.
- Amenorrea primaria (sin menarquia a los 15 años o sin caracteres sexuales a los 13): sin útero, cariotipo (Rokitansky 46,XX con vello normal; Morris 46,XY sin vello); con útero, FSH alta (Turner, talla baja) o baja (Kallmann, anosmia); himen imperforado con dolor cíclico.
- Inicial: cabergolina en hiperprolactinemia, recuperar peso y moderar ejercicio en la amenorrea hipotalámica funcional, levotiroxina si hay hipotiroidismo; terapia hormonal hasta los 50 años en la insuficiencia ovárica prematura.
- Derivar a ginecología o endocrinología: amenorrea primaria, macroprolactinoma con compromiso visual (RM urgente), gónada con cromosoma Y (gonadectomía), Asherman (histeroscopía) e insuficiencia ovárica prematura.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 17 años consulta por amenorrea primaria. Al examen: desarrollo mamario Tanner V, con ausencia completa de vello axilar y púbico. La vagina termina en un fondo ciego corto y se palpan masas móviles no dolorosas en ambos conductos inguinales. Está a la espera del resultado del cariotipo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
B Síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos (Morris)
C Síndrome de Turner
D Síndrome de Kallmann
E Himen imperforado

Respuesta B. Mamas desarrolladas con ausencia total de vello axilar y púbico, más masas inguinales (testículos), definen el síndrome de Morris. En Rokitansky el vello es normal; en Turner hay talla baja y mamas poco desarrolladas; en Kallmann no hay desarrollo mamario ni vello, y hay anosmia; el himen imperforado da dolor cíclico con útero presente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 19

Una paciente de 22 años consulta por amenorrea de 4 meses de evolución, sin otras alteraciones. Se realiza exámenes, que muestran test de embarazo negativo, TSH y prolactina, que están dentro de rangos normales. Se solicita prueba de progesterona, que resulta negativa y prueba de estrógeno y progesterona, que resulta positiva. Además, se solicita LH y FSH, que están normales, dentro del límite bajo. El diagnóstico más probable es:

A Prolactinoma
B Falla ovárica primaria
C Embarazo ectópico
D Amenorrea hipotalámica
E Síndrome de ovario poliquístico

Respuesta D. Tiene un hipogonadismo hipogonadotrófico (las gonadotropinas normales se consideran como hipogonadotrófico), por lo que es de causa hipotalámica o hipofisiaria (el hipo- hipo es hipo-hipo).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 153

Una paciente de 16 años, sin antecedentes, es traída por no presentar aún menarquia, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia talla de 1.53 metros y desarrollo puberal tanner 1, sin otros hallazgos. Se realiza test de progesterona que resulta negativo. El diagnóstico más probable en este caso es:

A Anovulación
B Malformación uterina
C Hipopituitarismo
D Hipotiroidismo
E Síndrome de turner

Respuesta E. Tiene retraso puberal, talla de 1,53 metros (no es talla baja propiamente tal, pero es una talla que no descarta Turner) y probablemente un hipogonadismo. No tiene clínica de hipopituitarismo (hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal), sino solo del hipogonadismo. Todo hipogonadismo en una niña es un Turner, hasta que se demuestre lo contrario, en particular si es baja.

▶ VER CLASE 1.03.1.011 **Síndrome climatérico** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.12 · Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos

QUÉ HAY QUE SABER

- Menopausia: diagnóstico clínico tras 12 meses sin regla en mujer >45 años; no pedir FSH de rutina (solo si se sospecha falla ovárica antes de los 40).
- Síntomas: a corto plazo bochornos, sudoración nocturna, insomnio y labilidad; a mediano plazo síndrome genitourinario (sequedad, dispareunia, disuria); a largo plazo osteoporosis y riesgo cardiovascular.
- Terapia hormonal si los síntomas afectan la calidad de vida, dentro de la ventana de oportunidad (<60 años o <10 años de menopausia): con útero, estrógeno + progestágeno obligatorio; histerectomizada, estrógeno solo. Dosis mínima eficaz, preferir vía transdérmica si hay riesgo trombótico.
- Contraindicaciones absolutas: cáncer de mama o endometrio, trombosis o evento cardiovascular, sangrado uterino no estudiado, hepatopatía activa. Alternativas no hormonales: venlafaxina, ISRS (no paroxetina con tamoxifeno) o gabapentina; estrógeno vaginal tópico para la atrofia.
- Seguimiento completo: control anual con mamografía, PA, perfil lipídico y glicemia, densitometría según riesgo, y reevaluar periódicamente la necesidad de continuar la terapia; medidas generales (ejercicio, calcio, vitamina D, dejar el tabaco).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 53 años, con menopausia hace 2 años, consulta por bochornos intensos, unos 10 al día, que alteran su sueño y su trabajo. Tiene antecedente de cáncer de mama con receptores hormonales positivos, operado hace 4 años, en tratamiento con anastrozol. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado para sus bochornos?**

A Estradiol transdérmico más progesterona micronizada

B Venlafaxina

C Tibolona

D Estrógenos conjugados orales solos

E Esperar, porque los bochornos ceden solos en 6 meses

Respuesta B. El cáncer de mama hormonodependiente contraindica toda terapia hormonal, incluida la tibolona, que aumenta la recurrencia. Para bochornos moderados a severos se usan alternativas no hormonales: venlafaxina, ISRS (evitando paroxetina si usa tamoxifeno) o gabapentina, junto a medidas generales.

▶ VER CLASE 1.03.1.012 Hipogonadismo masculino

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.23 · Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha clínica: disminución de libido, disfunción eréctil, menos vello corporal y facial, testículos pequeños, ginecomastia, infertilidad, pérdida de masa muscular y osteoporosis.
- Confirmación con testosterona total matinal (repetida); luego LH y FSH para clasificar: altas = hipogonadismo primario o hipergonadotropo (Klinefelter 47,XXY con testículos pequeños y firmes, orquitis, quimioterapia o radioterapia); bajas o normales = central.
- Central: medir prolactina y pedir RM de silla turca (prolactinoma, macroadenoma, sobre todo si hay hemianopsia); Kallmann con anosmia; también obesidad, opioides, anabólicos y enfermedad crónica.
- Inicial: tratar causas reversibles (suspender anabólicos u opioides, bajar de peso, cabergolina si hay prolactinoma) y derivar a endocrinología para confirmar y definir terapia con testosterona (contraindicada con cáncer de próstata o mama, hematocrito alto o deseo de fertilidad).
- Seguimiento por el médico general durante el reemplazo: síntomas, testosterona, hematocrito (poliglobulia), PSA y tacto rectal en mayores de 40–50 años, y densitometría.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 171

Un paciente de 32 años consulta por disfunción sexual asociada a disminución del vello facial. Al examen físico presenta disminución del vello corporal y disminución bilateral del tamaño testicular. **¿Cuál es el estudio más adecuado para proseguir el enfrentamiento de este paciente?**

A Prolactina

B Testosterona y LH

C Espermiograma y FSH

D Ecografía testicular

E HCG y estradiol

Respuesta B. Disfunción sexual, menos vello y testículos pequeños son hipogonadismo clínico. Se confirma con testosterona total matinal y se mide LH para clasificarlo: LH alta indica falla testicular primaria (ej. Klinefelter); LH baja o normal indica causa hipotálamo-hipofisaria, que obliga a medir prolactina y a estudiar la silla turca.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 83

Hombre de 38 años con disminución de la libido, disfunción eréctil, fatiga y ginecomastia bilateral. Testículos de tamaño normal. ¿Cuál es el estudio de elección inicial?

A Testosterona total sérica matinal

B Ecografía testicular

C Espermograma

D FSH y LH

E Prolactina

Respuesta A. Hipogonadismo masculino: el estudio inicial es testosterona total sérica en la mañana (máxima entre 8-10 AM). Si está baja, se complementa con LH/FSH para clasificar en primario o secundario.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 145

Un paciente de 35 años, padre de tres hijos consulta por disfunción eréctil progre- siva que inició hace 3 meses. Su examen físico no muestra alteraciones, y su examen ge- nital y testicular resulta normal. Se solicitan exámenes que muestran testosterona de 190 ng/dL (valor normal: 280-1100ng/dL) y LH de 1,8 UI/L (valor normal: 1,5-20 UI/L). ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de este paciente?

A Espermiograma
B Ecografía testicular
C Niveles plasmáticos de FSH
D Resonancia magnética de hipófisis
E Niveles plasmáticos de estrógeno y progesterona

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Resonancia magnética de hipófisis). Tiene un hipogonadismo hipogonadotrópico, por tanto probablemente es hipota- lámico o hipofisiario.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 50

Un paciente de 35 años, desde hace un año, presenta debilidad muscular, disminución de la libido e impotencia sexual progresiva. Se realizan exámenes, que muestran prolactina normal, niveles de LH: 1,6 UI/L (valor normal: 1,8 a 8,6 UI/L) y de testosterona: 160 ng/dl (valor normal: 270 a 1.070 ng/dl). ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

A Ecografía testicular
B Niveles plasmáticos de estradiol
C Niveles de FSH
D Solicitar niveles de testosterona libre
E Resonancia magnética de hipófisis

Respuesta E. Tiene un hipogonadismo (testosterona baja) hipogonadotrópico (LH baja), por lo que es de causa hipotalámica o hipofisiaria ("el hipo hipo es hipo hipo"). Se estudia con RMN de hipófisis. Vale la pena mencionar que, si la LH hubiese estado normal, en la zona "baja" del rango normal, igualmente sería un hipogonadismo hipogonadotrópico.

▶ VER CLASE **1.03.1.013** **Tumores hipofisiarios**

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 7.20 · Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria
Endocrinología 7.21 · Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica
Endocrinología 7.22 · Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Adenomas hipofisarios: prolactinoma 40 %, no funcionante 30–35 %, somatotropo 15 %, corticotropo 10 %; microadenoma <10 mm, macroadenoma ≥10 mm. Diferencial: craneofaringioma (niños y >50 años, quístico calcificado), meningioma, quiste de Rathke.
- Sospecha: cefalea, hemianopsia bitemporal por compresión del quiasma, oftalmoplejía por invasión del seno cavernoso, síntomas de hipersecreción (amenorrea-galactorrea, acromegalia, Cushing) o de hipopituitarismo.
- Estudio triple: RM de silla turca con gadolinio, campimetría computarizada y perfil hormonal completo (prolactina, IGF-1, cortisol y ACTH, TSH y T4 libre, FSH/LH y esteroides sexuales).
- Inicial: prolactinoma, cabergolina aunque haya hemianopsia; reemplazar déficits (hidrocortisona antes que levotiroxina). Apoplejía hipofisaria (cefalea en trueno, pérdida visual, III par, hipotensión): hidrocortisona 100 mg EV inmediata y RM urgente.
- Derivar a endocrinología y neurocirugía: cirugía transesfenoidal en macroadenoma no funcionante compresivo, acromegalia y Cushing; incidentaloma no funcionante <10 mm asintomático, RM a los 12 meses.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 138

Una paciente cefalea de 4 semanas de evolución, mayor en las mañanas, que se asocia a vómitos y, además, refiere alteraciones visuales. Al examen físico tiene fuerzas y sensibilidad conservada en las 4 extremidades y en el campo visual se constata hemianopsia bitemporal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Tumor de la glándula pineal
B Glioma del nervio óptico
C Tumor de la base del lóbulo frontal
D Hiperprolactinemia
E Macroadenoma hipofisiario

Respuesta E. Cefalea con vómitos y hemianopsia bitemporal: masa que comprime el quiasma desde abajo. El diagnóstico es un macroadenoma hipofisario.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 111

Un paciente consulta por disminución del deseo sexual y de las erecciones. Además, presenta astenia y debilidad, que ha ido aumentando, desde hace algunos meses. También, refiere haber chocado con un mueble, por no haberlo visto, resultado con lesiones. Al examen físico se aprecia pálido, con disminución del vello corporal, tiene edema de extremidades inferiores y disminución de la visión en la zona temporal del campo visual. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio de este paciente?**

A Radiografía de silla turca
B Prolactinemia
C Resonancia magnética de silla turca
D Fondo de ojo
E TAC de cerebro

Respuesta C. Compresión del quiasma (choca con un mueble, pérdida del campo temporal) más hipopituitarismo (libido, astenia, pérdida de vello): tumor hipofisario. El examen de elección es la RM de silla turca.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 24

Una paciente de 32 años, consulta por un cuadro de 6 meses de amenorrea, asociado a secreción mamaria bilateral. No utiliza método anticonceptivo y es sexualmente activa. Además, ha presentado cefalea que ha aumentado en las últimas semanas, de predominio matinal. Al examen mamario se objetiva escasa galactorrea y al examen neurológico se constata presencia de una hemianopsia bitemporal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Craneofaringioma
B Macroadenoma hipofisiario
C Glioma cerebral
D Apoplejía hipofisiaria
E Accidente vascular encefálico

Respuesta B. Amenorrea-galactorrea (hiperprolactinemia) más hemianopsia bitemporal (compresión del quiasma): macroadenoma hipofisario. La apoplejía sería un cuadro agudo con cefalea en trueno.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 123

Paciente con astenia, disminución de la libido, disfunción eréctil progresiva y alteración visual en zonas temporales. **¿Cuál es el examen de elección?**

A RNM de silla turca
B Campo visual computarizado
C TAC de cerebro con contraste
D Testosterona total sérica y FSH/LH
E Ecografía testicular bilateral

Respuesta A. Hipogonadismo en un varón con defecto del campo visual temporal: masa selar que comprime el quiasma, típicamente un macroadenoma. El examen de elección es la resonancia de silla turca.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 113

Un paciente presenta astenia y aumento de tamaño de la mandíbula, con separación entre los dientes. Además refiere hipertrofia malar, de la nariz y las manos. También ha aumentado el número de sus zapatos. **¿Qué examen es más adecuado para continuar el estudio de este paciente?**

A Niveles de hormona de crecimiento
B Radiografías de pies y de la arcada dentaria
C Radiografía de manos
D Niveles de IGF-1
E Resonancia magnética de hipófisis

Respuesta D. La acromegalia se estudia primero con somatomedina C o IGF-1 (son sinónimos). La GH es muy errática y no se pide.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 32

Un paciente de 30 años presenta astenia, malestar general y sudoración nocturna desde hace dos meses. Al examen físico registra frecuencia cardíaca: 89 lpm, presión arterial: 130/90 mmHg, se observa prognatismo y dedos de las manos gruesos. **¿Cuál de las siguientes hormonas estará elevada con mayor probabilidad?**

A Tiroxina
B Factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1)
C FSH
D Tirotropina (TSH)
E ACTH

Respuesta B. La sospecha es una acromegalia, producida por un tumor hipofisario productor de GH. El examen de elección es la IGF-1, que estará elevada.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 46 años con 5 años de cambio progresivo de rasgos faciales, separación dental con maloclusión y aumento de talla de zapatos de 41 a 44. Su cónyuge relata ronquidos con pausas respiratorias. Examen: macroglosia, nariz ancha, prognatismo, manos grandes, PA 160/95 mmHg. Glicemia de ayuno 142 mg/dL. Se sospecha acromegalia. **¿Cuál es el primer examen que debe solicitarse?**

A Hormona de crecimiento basal matinal

B IGF-1 sérica

C Resonancia magnética de silla turca con gadolinio

D Prolactina plasmática

E Radiografía de manos y pies

Respuesta B. Clínica clásica de acromegalia. El tamizaje de primera línea es la IGF-1, que integra la secreción de GH de las últimas semanas. La GH basal es pulsátil y no sirve. La RM se pide después de confirmar con PTGO. Luego: cirugía transesfenoidal, colonoscopía y ecocardiograma.

▶ VER CLASE 1.03.1.014 Hipopituitarismo

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.23 · Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipopituitarismo: déficit de una o más hormonas hipofisarias por macroadenoma, cirugía o radioterapia selar, apoplejía o síndrome de Sheehan (necrosis hipofisaria tras hemorragia obstétrica con shock).
- Sheehan: agalactia (síntoma más precoz), amenorrea, pérdida de vello axilar y pubiano, hipotiroidismo (astenia, frío, piel seca) y déficit corticotropo (hipotensión, hiponatremia, hipoglicemia).
- Sello bioquímico: hormona periférica baja con tropina baja o inapropiadamente normal (cortisol bajo con ACTH no elevada; T4 libre baja con TSH normal o baja; estradiol o testosterona bajos con FSH/LH no elevadas); RM de silla turca (adenoma o silla turca vacía).
- Regla de oro: hidrocortisona 15–20 mg/día primero y levotiroxina 24–48 h después (la levotiroxina sola puede precipitar una crisis suprarrenal); luego esteroides sexuales según edad y deseo de fertilidad. En crisis, hidrocortisona 100 mg EV.
- Derivar a endocrinología. Controlar la levotiroxina con T4 libre (no con TSH) y la hidrocortisona por clínica; educar en dosis de estrés.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 109

Una paciente de 28 años, se realiza una histerectomía postparto, por una inercia uterina. Usted la atiende 6 meses después, sin lactancia y permaneciendo en amenorrea. Presenta un cuadro de astenia, adinamia y malestar general, asociada a debilidad. Tiene piel seca, con cabello quebradizo, palidez y su presión arterial es de 90/60 mmHg. **El diagnóstico más probable es:**

A Tiroiditis postparto

B Panhipopituitarismo

C Depresión postparto

D Insuficiencia ovárica

E Hipotiroidismo

Respuesta B. Hemorragia obstétrica seguida de agalactia, astenia, piel seca e hipotensión: síndrome de Sheehan, con falla de varios ejes hipofisarios (tiroideo, suprarrenal, lactotropo). El hipotiroidismo que tiene es central; por eso se descarta la insuficiencia suprarrenal antes de dar levotiroxina.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años, con cefaleas esporádicas previas, consulta por 3 horas de cefalea holocraneana súbita "en estallido", vómitos, ptosis derecha, diplopía y somnolencia. PA 85/50 mmHg. Parálisis completa del III par derecho con midriasis y defecto campimétrico bitemporal severo. TC: masa selar con focos de hemorragia aguda. **¿Cuál es la medida inicial de máxima prioridad?**

A Manitol al 20 % en infusión rápida

B Hidrocortisona 100 mg EV en bolo

C Cabergolina por sonda nasogástrica

D Heparina de bajo peso molecular subcutánea

E Somatostatina EV continua

Respuesta B. Apoplejía hipofisaria: la hemorragia destruye la hipófisis, cae la ACTH y aparece una insuficiencia suprarrenal aguda secundaria (hipotensión). La primera medida es hidrocortisona 100 mg EV inmediata; luego RM y descompresión transesfenoidal urgente por el compromiso visual.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 36 años con astenia invalidante, intolerancia al frío y piel seca. Hace 2 años, parto complicado con hemorragia por atonía uterina, politransfusión e histerectomía. Nunca logró amamantar y no ha vuelto a menstruar. Pálida, cérea, PA 90/60 mmHg, sin vello axilar ni pubiano. T4L 0,4 ng/dL, TSH 1,1 mUI/L, cortisol 1,9 mcg/dL, ACTH 6 pg/mL, FSH 1,8 UI/L. **¿Cuál es la conducta terapéutica inicial más adecuada?**

A Levotiroxina 100 mcg/día y controlar TSH en 6 semanas

B Hidrocortisona oral y, 24–48 horas después, levotiroxina

C Estrógenos y progestágenos para recuperar las menstruaciones

D Levotiroxina e hidrocortisona el mismo día, luego ajustar según TSH

E Cabergolina para recuperar la lactancia

Respuesta B. Síndrome de Sheehan: hemorragia posparto, agalactia, amenorrea y pérdida de vello, con hormonas periféricas bajas y tropinas bajas o inapropiadamente normales. Se inicia hidrocortisona y, 24–48 h después, levotiroxina, titulada con T4 libre. Partir con levotiroxina puede precipitar una crisis suprarrenal.

▶ VER CLASE 1.03.1.015

Diabetes insípida

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 7.24 · Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)
Nefrología 2.3 · Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Diabetes insípida: poliuria hipotónica >3–5 L/día con polidipsia y nicturia, osmolalidad urinaria <300 y densidad <1.005; sodio normal si accede al agua, hipernatremia si no.
- Central (falta de ADH): TEC, neurocirugía o cirugía selar, histiocitosis, sarcoidosis. Nefrogénica (resistencia renal): litio (causa n.º 1), hipercalcemia, hipokalemia.
- Diferencial con polidipsia primaria (psicógena), que no sube el sodio; descartar también diabetes mellitus (glucosuria).
- Confirmación: test de restricción hídrica seguido de desmopresina (2–4 mcg SC o 20 mcg nasal): si la osmolalidad urinaria sube más de 50 % es central; si sube menos, nefrogénica. Con hipernatremia ya presente, no restringir agua: directo a desmopresina.
- Inicial: asegurar acceso a agua y corregir la hipernatremia lentamente; desmopresina nasal u oral en la central; en la nefrogénica retirar la causa e hidroclorotiazida + amilorida. Seguimiento: derivar a endocrinología o nefrología.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 124

Niño operado de cirugía cerebral, luego presenta hipernatremia y poliuria. **¿Diagnóstico más probable?**

A Síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH)

B Diabetes mellitus tipo 1

C Hiperaldosteronismo secundario

D Diabetes insípida central

E Polidipsia psicogénica

Respuesta D. Poliuria con hipernatremia tras una neurocirugía: falta de ADH por daño hipotalámico o del tallo. El SIADH, por exceso de ADH, retiene agua y causa hiponatremia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 105

Una paciente de 16 años de edad, con cuadro caracterizado por polidipsia y poliuria desde hace aproximadamente 3 semanas, no asociado a otros síntomas. Se realizan exámenes donde destaca osmolaridad plasmática disminuida, por lo que se solicita test de la sed que muestra normalización de diuresis y osmolaridad plasmática. **El diagnóstico más probable es:**

A Polidipsia psicógena

B Diabetes insípida nefrogénica

C Diabetes insípida central

D Hipercalcemia

E Diabetes mellitus tipo 1

Respuesta A. Poliuria y polidipsia con osmolaridad plasmática baja: el exceso es de agua ingerida. Al restringir el agua (test de la sed), la diuresis y la osmolaridad se normalizan porque el riñón y la ADH funcionan: polidipsia psicógena. En la diabetes insípida la osmolaridad plasmática tiende a estar alta y la poliuria persiste con la privación.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 22 años con TEC cerrado y fractura de base de cráneo. Al tercer día en UCI presenta poliuria de 600 mL/hora durante 4 horas. Na 150 mEq/L, Osm urinaria 140 mOsm/kg. Se sospecha diabetes insípida central. **¿Cuál es la prueba diagnóstica y terapéutica inicial de elección?**

A Prueba de privación de agua por 12 horas

B Dosis de prueba de desmopresina y Osm urinaria seriada

C Resonancia magnética de silla turca con gadolinio

D Vasopresina plasmática tras suero hipertónico

E Hidroclorotiazida más amilorida

Respuesta B. Poliuria hipotónica con hipernatremia tras un trauma de base de cráneo: sospecha de DI central. Con hipernatremia establecida, la privación de agua está contraindicada. La dosis de prueba de desmopresina confirma el diagnóstico si la Osm urinaria sube más de 50% y el volumen urinario cae, y a la vez trata. Tiazida + amilorida es para la DI nefrogénica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 80

Hombre con poliuria, polidipsia y nicturia. Toma 8 lts de agua al dia. En los exámenes destaca hiponatremia, como inicia el estudi n o?:

A Ecografía renal

B Electrolitos urinarios (no puede ser esta? Dice estudio inicial, se necesita la osm urinaria y luego deprivar y comparar o no??? -> Pero estudio de deprivación incluye la medición de OsmU y NaU pre y post deprivación), es esta, salía en ensayos anteriores

C TAC de no se q

D Test de deprivación de agua (esto es para hipernatremia sg yo)

E Derivar a psiquiatría f. PTGO

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Electrolitos urinarios (no puede ser esta? Dice estudio inicial, se necesita la osm urinaria y luego deprivar y comparar o no??? -> Pero estudio de deprivación incluye la medición de OsmU y NaU pre y post deprivación), es esta, salía en ensayos anteriores). El SIADH se produce por exceso de hormona antidiurética, que retiene agua y causa hiponatremia.

▶ VER CLASE 1.03.1.016 Hiperprolactinemia

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 7.21 · Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica
Ginecología 20.1 · Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

QUÉ HAY QUE SABER

- La prolactina vive frenada por la dopamina: sube con prolactinoma, fármacos anti-D2, compresión del tallo, hipotiroidismo primario, insuficiencia renal o cirrosis, y causas fisiológicas (embarazo, lactancia, estrés, estimulación del pezón).
- Clínica: en la mujer amenorrea u oligomenorrea, infertilidad y galactorrea; en el hombre debut tardío con baja libido, disfunción eréctil y ginecomastia, a menudo con macroadenoma (cefalea, hemianopsia bitemporal).
- Estudio: beta-hCG primero; prolactina en ayunas y reposo (>25 ng/mL); revisar fármacos (risperidona, haloperidol, metoclopramida, domperidona, ISRS) y medir TSH y creatinina. 25–100 sugiere fármacos, hipotiroidismo o microadenoma; >200–250, macroprolactinoma casi seguro.
- Descartadas causas secundarias y si persiste: RM de silla turca con gadolinio y campimetría si es macroadenoma. Hipotiroidismo: tratar con levotiroxina; fármaco: cambiarlo si es posible.
- Prolactinoma de cualquier tamaño: cabergolina 0,5 mg 1–2 veces por semana (normaliza la prolactina en 85–90 % y reduce el tumor); cirugía solo si hay resistencia o intolerancia. Derivar a endocrinología; control de prolactina a los 3 meses y RM al año.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 131

Una paciente de 25 años, sin antecedentes de importancia, consulta por mastalgia bilateral de 5 días de evolución. Al examen físico, se observa galactorrea bilateral al comprimir los pezones. Su FUR fue hace 12 días y no toma medicamentos. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar el estudio? **¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar el estudio?**

A Subunidad beta de gonadotropina coriónica humana en plasma

B Prolactinemia

C Resonancia magnética de silla turca

D Ecotomografía mamaria

E Mamografía

Respuesta A. Ante galactorrea, lo primero es descartar embarazo, aunque la FUR sea reciente. Luego se busca hiperprolactinemia, cuya causa principal son los fármacos y después los adenomas hipofisarios.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 79

Una paciente de 26 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por historia de tres meses de amenorrea asociada a galactorrea, sin otros síntomas, con prueba de detección de bHCG en orina negativa en dos oportunidades. Su examen físico resulta normal, su índice de masa corporal es de 20. **El examen de elección para iniciar el estudio en este caso es:**

A Hormona estimulante tiroidea
B Prueba de progesterona
C Ecografía transvaginal
D Prolactina
E Prueba de estrógeno más progesterona

Respuesta D. Síndrome de amenorrea-galactorrea con embarazo descartado: es una hiperprolactinemia hasta demostrar lo contrario, y se inicia el estudio con prolactina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 111

Una paciente de 38 años, usuaria de anticonceptivos orales combinados desde hace 4 meses, consulta por galactorrea de algunas semanas de evolución, sin otros síntomas. Las mamas se palpan sin nódulos y se objetiva la galactorrea al comprimirlas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar niveles de progesterona
B Solicitar niveles de prolactina
C Cambiar los anticonceptivos a progestágenos solos
D Solicitar TAC de cerebro
E Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, LH y FSH

Respuesta B. Toda galactorrea fuera del embarazo y la lactancia se estudia primero con prolactina plasmática (junto a TSH y descartar fármacos). Los anticonceptivos enmascaran la amenorrea que acompañaría a una hiperprolactinemia. La imagen, que es la resonancia de silla turca y no la TAC, se pide solo con prolactina elevada sin causa secundaria.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 26 años, nulípara, con amenorrea secundaria de 8 meses y galactorrea bilateral espontánea desde hace 4 meses. No usa fármacos. Campo visual normal. Beta-hCG negativa, TSH 1,8 mUI/L. Prolactina en reposo 165 ng/mL (VN < 25). RM de silla turca: lesión intraselar de 7 mm compatible con microadenoma. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A Cirugía transesfenoidal
B Cabergolina oral
C Anticonceptivos orales combinados
D Levotiroxina
E Radiocirugía estereotáxica

Respuesta B. Microprolactinoma con amenorrea-galactorrea, con embarazo, hipotiroidismo y fármacos descartados. El tratamiento de primera línea de todo prolactinoma es médico con cabergolina: normaliza la prolactina, restablece ciclos ovulatorios y fertilidad, y reduce el tumor en más del 80 %.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 72

Una paciente de 35 años, usuaria de T de cobre desde hace 5 años, consulta porque, desde hace 8 meses está en amenorrea. Al examen físico tiene galactorrea bilateral a la compresión del pezón, sin otras alteraciones en el examen ginecobstétrico ni en el examen físico general. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A Niveles plasmáticos de HCG
B Resonancia magnética de silla turca
C Niveles plasmáticos de estradiol, progesterona, LH, FSH y TSH
D Ecografía transvaginal
E Prolactinemia

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Niveles plasmáticos de estradiol, progesterona, LH, FSH y TSH). 1.

▶ VER CLASE 1.03.1.017 Síndrome de secreción inapropiada de ADH

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.24 · Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)

QUÉ HAY QUE SABER

- SIADH: hiponatremia hipotónica euvolémica por ADH autónoma; el sodio urinario alto se debe a la natriuresis por péptidos natriuréticos.
- Criterios: Na <135 y osmolalidad plasmática <275; osmolalidad urinaria >100 (inapropiadamente concentrada); Na urinario >30–40; euvolemia clínica, con TSH, cortisol y función renal normales y sin diuréticos.
- Causas: cáncer pulmonar de células pequeñas (>70 % de los ectópicos), patología pulmonar (neumonía, TBC) y del SNC (meningitis, TEC, ACV), fármacos (ISRS, carbamazepina, ciclofosfamida), dolor y náuseas postoperatorias.
- Tratamiento: restricción hídrica a 500–1.000 mL/día y tratar la causa; el suero fisiológico puede empeorar la hiponatremia. Con convulsiones o coma, suero salino hipertónico al 3 % en infusión controlada.

- Corregir como máximo 8–10 mEq/L en 24 h por riesgo de mielinólisis pontina. Seguimiento: control de natremia y búsqueda de la causa (radiografía de tórax, revisar fármacos); si es crónico, tolvaptán o urea por especialista.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 62 años con carcinoma pulmonar de células pequeñas en tratamiento, traído por astenia, náuseas, marcha inestable y confusión progresiva. Sin edema, mucosas húmedas, yugulares normales, PA 130/80 mmHg. Na 118 mEq/L, K 4,0 mEq/L, Osm plasmática 245 mOsm/kg, Osm urinaria 480 mOsm/kg, Na urinario 54 mEq/L. Función renal, TSH y cortisol normales. No ha convulsionado. **¿Cuál es la base del tratamiento?**

A Suero fisiológico 0,9 % a chorro

B Restricción hídrica a 500–1000 mL/día

C Desmopresina intranasal

D Furosemida y albúmina

E Corregir el sodio a 135 mEq/L en las primeras 24 horas

Respuesta B. SIADH paraneoplásico por oat cell: hiponatremia hipotónica euvolémica, Osm urinaria sobre 100, Na urinario sobre 30, con renal, tiroides y suprarrenal normales. La base es la restricción hídrica. Si convulsiona o entra en coma, salino al 3 % sin superar 8–10 mEq/L en 24 h, para evitar la mielinólisis pontina.

▶ VER CLASE 1.03.1.018 Osteoporosis

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 7.18 · Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento
Reumatología 9.24 · Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico: DEXA de columna y cadera; T-score ≤ −2,5 en cualquier sitio = osteoporosis, entre −1 y −2,5 osteopenia; la fractura por fragilidad (cadera, vértebra, húmero proximal, Colles tras caída de propia altura) es diagnóstica aunque el T-score no llegue a −2,5.
- Tamizaje con DEXA en mujeres ≥65 años o posmenopáusicas con factores de riesgo (corticoides, fractura previa, IMC <20, tabaco, alcohol, padre o madre con fractura de cadera). Laboratorio básico (calcio, fósforo, fosfatasas, función renal, 25(OH)D, TSH) para descartar causas secundarias.
- Tratar con fármacos si hay fractura por fragilidad, T-score ≤ −2,5, corticoides crónicos (prednisona ≥5–7,5 mg/día >3 meses) u osteopenia con FRAX ≥20 % fractura mayor o ≥3 % cadera.
- Alendronato 70 mg semanal (o risedronato) en ayunas con un vaso de agua de la llave, erguido 30–60 min sin comer; zoledrónico 5 mg EV anual si hay reflujo o mala adherencia. Siempre calcio 1.000–1.200 mg/día y vitamina D 800–2.000 UI/día; denosumab o teriparatida en casos seleccionados.
- Seguimiento: DEXA cada 1–2 años, prevención de caídas y vacaciones terapéuticas del bifosfonato a los 3–5 años (riesgo de osteonecrosis mandibular y fractura atípica de fémur).

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 114

Una paciente de 65 años, en tratamiento con calcio 2 gramos al día y vitamina D, 600 UI al día, se realiza una densitometría ósea que muestra un T score de -2,7 en la cadera derecha y de -2,8 en la columna lumbar. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar ejercicio aeróbico

B Indicar reposo relativo

C Aumentar dosis de vitamina D y calcio

D Agregar bifosfonatos al tratamiento

E Mantener el tratamiento

Respuesta D. T-score ≤ -2,5: osteoporosis. Calcio y vitamina D son la base, pero no bastan: se agrega el bifosfonato y se mantienen los suplementos.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 67 años, menopáusica desde los 50 sin terapia hormonal, sin fracturas previas. DEXA: T-score -2,8 en columna lumbar y -2,6 en cuello femoral. Calcemia, fosfemia, fosfatasas alcalinas, función renal y hemograma normales. Sin reflujo ni pirosis. Se inicia alendronato 70 mg semanal. **¿Qué indicación de administración es correcta?**

A Tomarlo en la noche, antes de acostarse, con un vaso de leche

B Tomarlo con el desayuno para evitar la irritación gástrica

C Tomarlo en ayunas con un vaso lleno de agua de la llave y mantenerse erguida 30 a 60 minutos

D Tomarlo junto con el comprimido de calcio para que se absorban juntos

E Disolverlo en jugo de naranja para mejorar su absorción

Respuesta C. Osteoporosis densitométrica (T-score ≤ -2,5): bifosfonato con calcio y vitamina D. El alendronato se absorbe menos del 1 %: en ayunas, solo con agua de la llave, erguida 30–60 minutos y sin comida ni otros fármacos, para asegurar la absorción y evitar la esofagitis.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 76 años previamente autovalente resbala en el pasillo de su casa y cae desde su propia altura, sufriendo dolor intenso en la ingle derecha e incapacidad funcional para la bipedestación. La radiografía de pelvis confirma una fractura subcapital desplazada del cuello femoral derecho, por lo que es hospitalizada para artroplastía de cadera. No cuenta con densitometría ósea previa. ¿Cuál es el diagnóstico esquelético que se establece clínicamente de manera automática y cuál es la conducta farmacológica apropiada para el alta?

A Osteopenia leve; indicar suplemento de vitamina D3 aislada y solicitar densitometría ósea ambulatoria antes de cualquier fármaco

B Osteoporosis clínica establecida; iniciar tratamiento con calcio, vitamina D y terapia antirresortiva (bifosfonato o denosumab) sin requerir densitometría previa

C Trauma mecánico aislado sin osteoporosis; no requiere tratamiento farmacológico óseo ya que la fractura es traumática

D Osteomalacia por déficit de calcio; indicar calcitriol a altas dosis y diferir los antirresortivos de forma definitiva

E Artrosis de cadera complicada; iniciar condroitín sulfato y AINEs de forma indefinida

Respuesta B. Toda fractura producida por un traumatismo de bajo impacto (caída desde la propia altura) en sitios cardinales como cadera o columna vertebral en un adulto mayor establece por sí misma el diagnóstico clínico de Osteoporosis (incluso Osteoporosis Severa/Establecida). No es necesario realizar ni esperar una densitometría ósea previa para justificar el inicio de terapia antirresortiva farmacológica (bifosfonato como alendronato o ácido zoledrónico, o denosumab) asociada a suplementación de calcio y vitamina D.

▶ VER CLASE 1.03.1.019 Osteoporosis secundaria

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 7.18 · Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar osteoporosis secundaria en hombres jóvenes, mujeres premenopáusicas, Z-score ≤ −2,0, fracturas con mínimo trauma a edad temprana o pérdida ósea desproporcionada.
- En premenopáusicas y hombres menores de 50 años se usa el Z-score (compara con la misma edad): ≤ −2,0 = densidad baja para la edad y obliga a buscar causa.
- Causas: corticoides (la más frecuente), hipogonadismo, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, Cushing, déficit de vitamina D u osteomalacia, malabsorción (celiaquía), alcoholismo, mieloma, artritis reumatoide.
- Estudio inicial: calcio, fósforo, PTH, 25(OH)D, TSH, testosterona, función renal y hepática, hemograma, electroforesis de proteínas; según clínica antitransglutaminasa y cortisol libre urinario.
- Inicial: calcio y vitamina D, suspender o reducir corticoides si es posible y no dar bifosfonato antes de corregir el déficit de vitamina D. Seguimiento: derivar para tratar la causa y definir el antirresortivo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 45 años presenta una fractura vertebral por aplastamiento tras un esfuerzo mínimo. La densitometría muestra un Z-score de −3,0 en columna. No tiene antecedentes conocidos ni usa fármacos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar bifosfonato sin otro estudio, porque es osteoporosis primaria

B Repetir la densitometría en 2 años

C Indicar solo calcio y vitamina D

D Buscar causas secundarias: calcio, fósforo, PTH, vitamina D, TSH, testosterona, función renal y hepática, hemograma y electroforesis de proteínas

E Iniciar terapia con estrógenos

Respuesta D. Osteoporosis en un hombre joven o con Z-score bajo −2 obliga a buscar causas secundarias: hipogonadismo, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, Cushing o corticoides, déficit de vitamina D, malabsorción (enfermedad celíaca), alcoholismo o mieloma, entre otras. Tratar la causa es parte central del manejo, junto al antirresortivo.

▶ VER CLASE 1.03.1.020 Hipercalcemias e hipocalcemias

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 7.16 · Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico
Endocrinología 7.17 · Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Siempre corregir por albúmina: calcio corregido = calcio + 0,8 × (4 − albúmina); en hipoalbuminemia puede ser una seudohipocalcemia (medir calcio iónico si hay duda).
- Hipercalcemia (>10,5 mg/dL): «huesos, cálculos, quejidos y gemidos» (dolor óseo, litiasis, poliuria, constipación, náuseas, letargia, QT corto). Primer examen: PTH; alta o inapropiadamente normal = hiperparatiroidismo primario (adenoma 85 %); suprimida = neoplasia (PTHrP, osteólisis), exceso de vitamina D o granulomas.
- Hipocalcemia: parestesias periorales, espasmo carpopedal, Chvostek y Trousseau, laringoespasmo, convulsiones y QT largo; causas: posquirúrgica (24–72 h post tiroidectomía), hipomagnesemia, déficit de vitamina D, pancreatitis, transfusión masiva.
- Inicial: hipercalcemia leve (<12), hidratación oral y suspender tiazidas y litio; ≥12 sintomática, hospitalizar con suero fisiológico EV. Hipocalcemia sintomática: gluconato de calcio 10 % EV y medir magnesio.
- Derivar a endocrinología: hiperparatiroidismo primario (paratiroidectomía si sintomático o cumple criterios), hipercalcemia PTH-independiente (buscar cáncer) e hipoparatiroidismo crónico (calcio oral + calcitriol, meta 8,0–8,5).

PREGUNTAS · 12

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 175

Un paciente de 32 años, con antecedente de litiasis renal a repetición se realiza exámenes, que muestran calcio plasmático: 9,8 mg/dl, albúmina: 3,0 g/dl, creatinina plasmática: 0,7 mg/dl, PTH: 90 UI/L (VN: 10 a 55 pg/ml) y calciuria de 200 mg/día (VN: 50 a 150 mg/día). **El diagnóstico más probable es:**

A Hiperparatiroidismo primario
B Hiperparatiroidismo secundario
C Hiperparatiroidismo terciario
D Hipercalciuria primaria
E Hipercalciuria familiar

Respuesta A. Calcio corregido = 9,8 + 0,8 × (4 − 3) = 10,6 mg/dL: hay hipercalcemia. Con PTH elevada e hipercalciuria que explica la litiasis, es un hiperparatiroidismo primario. El secundario tiene calcio bajo o normal (típico de la IRC); en la hipercalciuria primaria la calcemia y la PTH son normales.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 167

Hombre de 55 años asintomático con calcio sérico 11.2 mg/dL, fósforo 2.1 mg/dL (bajo) y PTH 145 pg/mL (elevada). Sin otros hallazgos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hiperparatiroidismo primario
B Hipercalcemia hipocalciúrica familiar
C Hipercalcemia de malignidad
D Intoxicación por vitamina D
E Sarcoidosis

Respuesta A. Hipercalcemia + hipofosfatemia + PTH elevada en un paciente ambulatorio asintomático: hiperparatiroidismo primario, la causa más frecuente en este contexto. Malignidad, vitamina D y sarcoidosis tienen la PTH suprimida.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 121

Un paciente de 67 años consulta por dolores óseos en múltiples zonas. Se realiza exámenes, entre los que destaca calcemia corregida de 14,4 mg/dl, con pruebas de función renal normales. Además, se solicitan radiografías que muestran imágenes sugerentes de metástasis óseas. **¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?**

A Calciuria de 24 horas
B Niveles plasmáticos de 25-OH vitamina D
C Niveles plasmáticos de paratohormona
D Cintigrafía ósea
E Niveles plasmáticos de calcio iónico

Respuesta C. Toda hipercalcemia se estudia con PTH: si está elevada es hiperparatiroidismo primario; si está suprimida, apoya el origen neoplásico. Las lesiones óseas también pueden deberse a hiperparatiroidismo (tumores pardos). La cintigrafía es inespecífica y aquí las lesiones ya se vieron.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 78

Paciente de 63 años, con antecedente de hipernefroma operado hace un año, con buena evolución, consulta por cuadro de astenia y debilidad de 7 días, controlándose exámenes de sangre entre los que destaca calcemia de 11,8 mg/dL (valor normal 8,5-10,5 mg/dL), albúmina normal. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de este paciente? **¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?**

A Cintigrafía ósea
B Niveles plasmáticos de calcio y paratohormona
C TAC de abdomen y pelvis
D Niveles plasmáticos de vitamina D
E Resonancia magnética de abdomen y pelvis

Respuesta B. Es una hipercalcemia, posiblemente paraneoplásica. Se estudia siempre con paratohormona: si está elevada, es hiperparatiroidismo primario; si está baja, es probablemente cáncer.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 56 años con astenia, constipación de 3 meses, dolores óseos difusos y 2 cólicos renales en los últimos 2 años. Lúcida, hidratada, PA 135/85 mmHg. Calcio 11,6 mg/dL con albúmina 4,0 g/dL, fósforo 2,1 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL, PTH intacta 145 pg/mL (VN 15–65). Ecografía renal: microlitiasis bilateral. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Ácido zoledrónico 4 mg EV
B Control anual de calcio y densitometría
C Localizar con cintigrama sestamibi y ecografía cervical, y paratiroidectomía
D Furosemida oral y restricción de lácteos
E Electroforesis de proteínas para descartar mieloma

Respuesta C. Hipercalcemia + hipofosfatemia + PTH elevada: hiperparatiroidismo primario. Es sintomática (litiasis recurrente), así que la cirugía es mandatoria: se localiza el adenoma con sestamibi y ecografía y se hace paratiroidectomía. La observación solo cabe en el asintomático sin criterios; con PTH elevada, el mieloma no explica el cuadro.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 54 años, alcohólico crónico y desnutrido, ingresa con tetania y parestesias. Calcio sérico 6,8 mg/dL. Recibe dos bolos EV de gluconato de calcio al 10 %, pero persiste tetánico con calcio de 6,9 mg/dL. **¿Qué examen se debe solicitar de inmediato?**

A Magnesemia
B Calcitonina sérica
C TSH
D Ácido fólico plasmático
E Plombemia

Respuesta A. Hipocalcemia refractaria a calcio EV en un alcohólico desnutrido: hipomagnesemia hasta demostrar lo contrario. Sin magnesio no se secreta PTH ni actúa en hueso y riñón. Se corrige con sulfato de magnesio EV y recién entonces responde el calcio.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 32

En el estudio de una osteoporosis de una paciente, se pesquisa tiene calcemia de 11 mg/dl, niveles de paratohormona de 155 UI/L (VN: 15 a 55), niveles de vitamina D: (VN:) y albúmina de 3,8 g/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Hipercalcemia idiopática
B Hiperparatiroidismo primario
C Hiperparatiroidismo secundario
D Hiperparatiroidismo terciario
E Hipercalcemia familiar

Respuesta B. Diagnóstico: Hiperparatiroidismo primario (opción B). Calcio alto y PTH alta son característicos del HPP. Clase sobre el tratamiento de la hipercalcemia e hipocalcemia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 8

Mujer de 58 años con calcio sérico de 11.8 mg/dL detectado en examen de rutina. Asintomática. Sin uso de suplementos de calcio ni vitamina D. ¿Cuál es el estudio inicial de elección para determinar la causa de la hipercalcemia?

A PTH sérica
B Fósforo sérico
C Calcitonina
D Calcio en orina de 24h
E Vitamina D (25-OH)

Respuesta A. PTH es el primer examen a solicitar en hipercalcemia: PTH elevada = hiperparatiroidismo primario (causa más frecuente en ambulatorio). PTH suprimida = hipercalcemia de malignidad, intoxicación vitamina D u otras causas. Orienta todo el estudio.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 33

Una paciente presenta su sexta litiasis urológica, por lo que se realizan exámenes, entre los que destacan creatinina: 1,2 mg/dl, BUN: 30 mg/dl, calcio: 11 mg/dl, fósforo: 2,3 mg/dl, natremia normal, potasemia normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio diagnóstico?

A Paratohormona
B LH y FSH
C 25 OH vitamina D
D Biopsia de médula ósea
E Índice proteinuria / creatininuria

Respuesta A. Diagnóstico: Paratohormona (opción A). La hipercalcemia se estudia con PTH. Además, la hipofosfemia orienta a un HPP. Clase sobre el tratamiento de la hipercalcemia e hipocalcemia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 89

Un paciente de 35 años ha presentado 6 episodios, en el último año, de litiasis renal por cálculos cálcicos. ¿Qué alteración endocrinológica puede ser causante de esto?

A Hipercortisolismo
B Hipocortisolismo
C Hiperprolactinemia
D Hiperparatiroidismo
E Hipoparatiroidismo

Respuesta D. El hiperparatiroidismo produce salida de calcio desde los huesos, lo que aumenta la calcemia y también la calciuria, produciendo litiasis urológica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 177

Un paciente de 50 años, sin antecedentes, acude a realizarse un chequeo, asintomático. Su examen físico es normal. Trae exámenes que se habría tomado la semana pasada donde destaca hemoglobina 14 mg/dL, leucocitos 7.000/mm3, plaquetas 230.000/mm3, creatinina 0.8 mg/dL, calcio 11, albúmina 4, electrocardiograma normal. La conducta más adecuada en este caso es:

A Mantener control ambulatorio anual
B Solicitar cintigrafía ósea
C Solicitar radiografía de huesos largos y huesos parietales
D Solicitar niveles de paratohormona
E Solicitar electroforesis de proteínas

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Solicitar niveles de paratohormona (opción D). Tiene el Calcio elevado (N menor a 10,5). Corregido por albúmina queda igual. Se debe pedir PTH.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 172

¿Cual es el estudio de Hipercalcemia ? a. Calcemia y PTH 173. Había un AM con alteraciones de memoria creo, con VCM > 100: B12 (ALGUIEN RECUERDA ALGO DE ESTO)

A Hemograma y VHS
B Ecografía
C Radiografía
D TAC con contraste
E Resonancia magnética

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Hemograma y VHS). Clase sobre el tratamiento de la hipercalcemia e hipocalcemia.

▶ VER CLASE 1.03.1.021 Nódulo tiroídeo

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.9 · Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF

QUÉ HAY QUE SABER

- Nódulos en 50–60 % de las mujeres por ecografía; solo 5–10 % son malignos (sobre todo papilar). Factores de riesgo: radiación cervical en la infancia, familiar con carcinoma medular o NEM 2, crecimiento rápido, disfonía, adenopatías duras.
- Primer paso: TSH. Si está suprimida, cintigrama: nódulo caliente (autónomo) casi nunca es maligno y no se punciona. Si es normal o alta, ecografía con TI-RADS (el cintigrama no aporta).
- Signos ecográficos de sospecha: sólido, marcadamente hipoecogénico, más alto que ancho, márgenes irregulares, microcalcificaciones. PAAF: TR3 desde 2,5 cm, TR4 desde 1,5 cm, TR5 desde 1 cm; TR1–TR2 nunca.
- Bethesda: I repetir PAAF; II benigno, control ecográfico en 12–24 meses; III repetir PAAF o test molecular; IV hemitiroidectomía diagnóstica; V y VI cirugía (tiroidectomía total o lobectomía).
- Derivar a especialista (GES cáncer de tiroides) con Bethesda IV–VI o adenopatías sospechosas. La levotiroxina supresora está en desuso.

PREGUNTAS · 13

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 167

Un paciente de 30 años, presenta un nódulo tiroideo, que en el examen físico se palpa de consistencia elástica, indoloro, sin adenopatías cervicales. Se solicita TSH: 0,2 UI/L (VN: 0,3 a 5,0 UI/L), con T4 y T3 normales. Se solicita ecografía cervical, que muestra un nódulo tiroideo sólido, redondo, de aspecto homogéneo, sin microcalcificaciones, de 3 cm de diámetro. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar cintigrafía tiroidea
B Realizar punción con aguja fina
C Controlar con pruebas tiroideas en 6 meses
D Solicitar niveles de tiroglobulina
E Realizar cirugía

Respuesta A. La TSH está suprimida (hipertiroidismo subclínico con T4 y T3 normales). Con TSH baja, antes de puncionar se pide cintigrama: si el nódulo es caliente, es autónomo, casi nunca maligno y no requiere PAAF.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 65

Un paciente de 50 años consulta porque notó aumento de volumen en la zona anterior de su cuello. Al examen físico se palpa un nódulo de 2 cm de diámetro y consistencia dura. Se solicitan exámenes, entre los que destaca una TSH: 6,2 UI/L. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio?**

A T4 libre
B Ecografía cervical
C Cintigrafía tiroidea
D Estudio citológico por punción
E Anticuerpos antitiroideos

Respuesta B. Con TSH normal o elevada, el siguiente paso ante un nódulo es la ecografía cervical con clasificación TI-RADS, que define si corresponde PAAF. El cintigrama solo se pide con TSH suprimida.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 38

Un paciente se realiza una ecografía de cuello, como parte del estudio de un nódulo cervical, que visualiza un tumor sólido y redondeado, localizado en el istmo, de 4 mm de diámetro, sin presencia de adenopatías. Sus pruebas tiroideas muestran TSH y T4 libre dentro de rangos normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar tratamiento levotiroxina

B Iniciar levotiroxina en dosis de supresión

C Realizar punción con aguja fina

D Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo

E Realizar seguimiento ecográfico

Respuesta E. Un nódulo de 4 mm, sin adenopatías y con función tiroidea normal, no alcanza ningún umbral de PAAF: se vigila con ecografía. La levotiroxina supresora está en desuso y el cintigrama no se pide con TSH normal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 146

Una paciente de 42 años, consulta por adenopatía supraclavicular derecha persistente. Al examen físico se palpa además un nódulo cervical paratraqueal derecho de consistencia aumentada, que asciende con la deglución, de alrededor de 2 cm de diámetro. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio de esta paciente?**

A Niveles plasmáticos de calcitonina

B Ecografía cervical

C TAC de cuello

D Resonancia magnética de cuello

E Biopsia quirúrgica

Respuesta B. Un nódulo que asciende con la deglución es tiroideo, y junto a una adenopatía persistente sugiere cáncer con diseminación linfática. Aun así, el estudio parte con ecografía cervical, que caracteriza el nódulo y los ganglios y guía la punción. La calcitonina no es el examen inicial.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 39 años, sin antecedentes familiares ni de radiación. Nódulo tiroideo de 2 cm, TSH normal, clasificado como TI-RADS 4. Se realiza PAAF guiada por ecografía, cuyo informe concluye: Bethesda IV, neoplasia folicular. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Control ecográfico en 6 meses

B Hemitiroidectomía (lobectomía más istmectomía) diagnóstica

C Tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar bilateral

D Radioyodo I-131 en dosis ablativa

E Repetir la PAAF con aguja de mayor calibre

Respuesta B. Bethesda IV tiene un riesgo de cáncer de 25–40 %, y la citología no distingue adenoma de carcinoma folicular: eso exige ver invasión capsular o vascular en la pieza completa. La conducta es la hemitiroidectomía diagnóstica; si la histología confirma carcinoma, se completa la tiroidectomía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 51

Un paciente de 30 años presenta un cuadro de astenia y piel seca. Al examen se detecta un nódulo tiroideo, que se palpa de 15 mm de diámetro, en relación al lóbulo derecho. Se solicita TSH y T4 libre, que resultan normales. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de esta paciente?

A Ecografía cervical

B Biopsia citológica por punción con aguja fina

C Biopsia excisional

D Cintigrafía tiroidea

E Captación de yodo radiactivo

Respuesta A. El estudio de un nódulo tiroideo con TSH normal comienza con la ecografía cervical, que describe tamaño, características sospechosas y guía la punción con aguja fina. La captación de yodo radiactivo y la cintigrafía solo se usan si la TSH está suprimida, y la biopsia excisional no es un examen inicial.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 154

Paciente con antecedente de AVE isquémico; en ecografía Doppler carotídeo se ve nódulo tiroideo de 10 mm, quístico, bordes regulares, sin vascularización. ¿Cuál es la conducta?

A PAAF del nódulo

B Cintigrafía tiroidea

C Derivar a cirugía de cuello

D Controlar con ecografía en un año

E TSH y T4 libre

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Controlar con ecografía en un año (opción D). Controlar con ecografía en un año. Estudio del nódulo tiroideo: TSH + ecografía. Si TSH suprimida → cintigrafía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 16

Un paciente de 32 años, con antecedente de familiar con cáncer de tiroides, acude a la consulta. Trae una ecografía cervical, que muestra un nódulo tiroideo de 7 mm de diámetro de aspecto quístico, sin calcificaciones, con presencia de adenopatías inespecíficas pequeñas. Su TSH y T4 libre son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar punción aspiración con aguja fina
B Solicitar cintigrafía tiroidea
C Solicitar captación de yodo radiactivo
D Solicitar nueva ecografía en 6 meses
E Realizar tiroidectomía

Respuesta D. Los nódulos menores a 10 mm, en especial si son quísticos, se observan, debido a que con altísima probabilidad son un quiste coloideo. Se controla ecográficamente en 6 meses.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 23

Un paciente de 32 años, con antecedente de madre con cáncer de tiroides, por lo que se realiza una ecografía cervical, que muestra un nódulo tiroideo de 7 mm de diámetro y aspecto quístico. Su TSH y T4 libre son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar punción aspiración con aguja fina
B Solicitar cintigrafía tiroidea
C Solicitar captación de yodo radiactivo
D Solicitar nueva ecografía en 6 meses
E Realizar tiroidectomía

Respuesta D. Todo nódulo tiroideo se estudia con Ecografía y TSH + T4L. Si tiene más de 10 mm, se punciona con PAAF. Si tiene menos de 10 mm, se sigue (este caso). Si tiene TSH baja (hipertiroidismo) se estudia con cintigrafía toroidea.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 101

Un hombre de 59 años, fumador, presenta un accidente vascular encefálico, que se maneja rápidamente, por lo que se recupera sin dejar secuelas. Posteriormente, se realiza ecografía Doppler carotidea como estudio de fuente embólica, que no muestra alteraciones arteriales, pero sí identifica la presencia de un nódulo tiroideo de 1 cm de diámetro, de aspecto quístico, bien delimitado y capsulado. Se solicitan pruebas tiroideas que muestran TSH: 2,1 microU/ml (VN: 0,5 a 5,0) y T4 libre que resulta 1,2 ng/dl (VN: 0,9 a 2,2). ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto del nódulo tiroideo?

A Realizar punción con aguja fina
B Controlar en 6 meses con nueva ecografía
C Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
D Iniciar levotiroxina
E Realizar biopsia excisional quirúrgica

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar punción con aguja fina (opción A). Estudio del nódulo tiroideo: TSH + ecografía. Si TSH suprimida → cintigrafía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 22

Un paciente de 28 años, fumador, consulta por aumento de volumen cervical. Al examen físico se palpa nódulo paratraqueal derecho, de 3 cm de diámetro y consistencia aumentada, que asciende con la deglución. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Quiste tirogloso
B Quiste branquial
C Cáncer de laringe
D Adenopatía metastásica
E Nódulo tiroideo

Respuesta E. Ascienden con la deglución solo la el QTG y el nódulo tiroideo. Pero el QTG está en la línea media y no en el lado derecho, como este caso.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 92

Mujer de 37 años, sin antecedentes, consulta por aparición de aumento de volumen cervical anterior, no asociado a otros síntomas. Al examen físico destaca nódulo a nivel tiroídeo de consistencia aumentada, que asciende a la deglución. Como parte del estudio se realiza TSH que resulta normal. La conducta inicial más adecuada en este caso es:

A Solicitar punción con aguja fina
B Solicitar Cintigrafía con I131
C Solicitar ecografía cervical
D Solicitar anticuerpos anti tiroperoxidasa
E Solicitar niveles de T3 y T4L

Respuesta C. Eco y PAAF son respuestas correctas. Como no dice el tamaño, primero la ecografía, para ver el aspecto y descartar adenopatías. Así lo dice la guía minsal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 25

Una paciente de 25 años presenta un nódulo tiroideo de 2 cm de diámetro, a la palpación. Se solicita TSH t T4 libre, que resultan normales. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de esta paciente?

A Ecografía cervical
B Punción aspiración con aguja fina
C Anticuerpos antiroideos
D Cintigrafía con yodo radiactivo
E TAC cervical

Respuesta A. Ante un nódulo tiroideo, lo primero es pedir TSH, luego la ecografía y luego la punción con aguja fina (si es mayor a 10 mm).

▶ VER CLASE 1.03.1.022 Incidentaloma suprarrenal

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.15 · Feocromocitoma y Paragangliomas: Bloqueo Alfa Obligatorio

QUÉ HAY QUE SABER

- Masa suprarrenal ≥1 cm hallada en una imagen solicitada por otro motivo; la mayoría son adenomas no funcionantes.
- Todo incidentaloma requiere estudio funcional: test de supresión con 1 mg de dexametasona (Cushing subclínico) y metanefrinas plasmáticas o urinarias (feocromocitoma); aldosterona y renina si hay HTA o hipokalemia.
- Imagen: <10 UH sin contraste, homogéneo y de bordes nítidos sugiere adenoma rico en lípidos; tamaño >4 cm, heterogéneo, >10 UH o lavado lento sugiere carcinoma o feocromocitoma.
- No biopsiar: no distingue adenoma de carcinoma y es peligrosa si es feocromocitoma (salvo sospecha de metástasis, descartado antes el feocromocitoma).
- Derivar a endocrinología o cirugía si es funcionante, mide >4 cm o tiene imagen sospechosa (suprarrenalectomía); no funcionante pequeño y benigno, control clínico según especialista.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

A una mujer de 55 años, normotensa, se le encuentra en una TAC solicitada por cólico renal una masa suprarrenal izquierda de 2,5 cm, homogénea, de 8 UH sin contraste. No tiene signos de síndrome de Cushing. **¿Cuál es el estudio hormonal mínimo más adecuado?**

A Ningún estudio, por ser pequeño y homogéneo
B Test de supresión con 1 mg de dexametasona y metanefrinas plasmáticas o urinarias
C Solo cortisol libre urinario
D Biopsia percutánea de la masa
E Solo aldosterona y renina plasmáticas

Respuesta B. Todo incidentaloma suprarrenal requiere estudio funcional: supresión nocturna con 1 mg de dexametasona (Cushing subclínico) y metanefrinas (feocromocitoma); aldosterona y renina se agregan si hay HTA o hipokalemia. Menos de 10 UH sugiere adenoma rico en lípidos. La biopsia no se recomienda y es peligrosa si es feocromocitoma.

▶ VER CLASE 1.03.1.023 Ginecomastia

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.25 · Ginecomastia: Fisiológica, Farmacológica y Patológica

QUÉ HAY QUE SABER

- Ginecomastia: proliferación del tejido glandular mamario masculino (disco retroareolar firme, a menudo doloroso y bilateral); diferenciar de la pseudoginecomastia (grasa) y del cáncer de mama (unilateral, duro, excéntrico, fijo, con retracción o secreción).
- Fisiológica en recién nacidos, adolescentes (suele regresar en 6–24 meses) y adultos mayores. Patológica: fármacos (espironolactona, ketoconazol, antiandrógenos, cimetidina, anabólicos, marihuana), cirrosis, enfermedad renal crónica, hipertiroidismo, hipogonadismo (Klinefelter) y tumores productores de estrógenos o hCG (testicular).
- Estudio: anamnesis farmacológica y examen testicular; si no es fisiológica o es reciente o progresiva, pedir testosterona, LH, FSH, estradiol, beta-hCG, prolactina, TSH, perfil hepático y creatinina; ecografía testicular si hay hCG o estradiol alto o masa.
- Ecografía o mamografía si hay sospecha de cáncer de mama; en adolescentes con examen normal basta la observación y tranquilizar.
- Inicial: suspender el fármaco causal y tratar la causa. Derivar: masa sospechosa, tumor testicular, hipogonadismo, ginecomastia de >12 meses o con impacto estético (tamoxifeno precoz o cirugía por especialista).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 45

Adolescente masculino de 14 años con aumento bilateral del tejido mamario subareolar, sensible al tacto, sin secreción. No usa medicamentos. Su desarrollo puberal es Tanner 3. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuados?**

A Ginecomastia puberal fisiológica; tranquilizar y observar

B Cáncer de mama masculino; biopsia urgente

C Hiperprolactinemia; solicitar prolactina

D Hipogonadismo; solicitar testosterona

E Tumor testicular; solicitar ecografía testicular

Respuesta A. La ginecomastia puberal aparece en la mitad o más de los varones en Tanner 2 a 4; es bilateral, subareolar, a veces sensible, y regresa sola en 1 a 2 años. Se examinan los testículos y se revisan fármacos o drogas; si todo es normal, basta tranquilizar y controlar. El cáncer de mama es excepcional a esta edad.

Situaciones clínicas de urgencia

5 códigos

▶ VER CLASE 1.03.2.001 **Tormenta tiroidea** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.8 · Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Tormenta tiroidea: hipertiroidismo (habitualmente Graves no controlado) descompensado por un gatillante: infección, cirugía sin preparación, abandono de tionamidas, contraste yodado, parto o cetoacidosis.
- Diagnóstico clínico, sin esperar la T4 libre: fiebre, taquicardia o FA, insuficiencia cardíaca, compromiso del SNC (agitación, delirio, coma) y digestivo (vómitos, diarrea, ictericia). Burch-Wartofsky ≥45 altamente probable; 25–44 inminente.
- Manejo en UCI con cuatro pilares: 1) propranolol 60–80 mg c/4–6 h oral (o 1–2 mg EV); 2) propiltiouracilo carga 500–1.000 mg y luego 200–250 mg c/4 h; 3) Lugol 8–10 gotas c/8 h al menos 1 hora después del PTU; 4) hidrocortisona 100 mg EV c/8 h.
- Soporte: paracetamol y enfriamiento físico (aspirina contraindicada: libera T4 de la TBG), fluidos con suero glucosado y fisiológico; buscar y tratar el gatillante (cultivos, antibióticos).
- Refractaria a 24–48 h: plasmaféresis o tiroidectomía de salvataje. Seguimiento: derivar a UCI y endocrinología.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 46 años con hipertiroidismo reciente, en tratamiento irregular con tiamazol, con 3 días de tos productiva. Llega soporosa, sudorosa, T° 39,8 °C, PA 85/50 mmHg, FC 152 lpm en fibrilación auricular. Bocio difuso con soplo, crepitaciones bibasales e ictericia leve. Burch-Wartofsky: 75 puntos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar T4 libre y T3 y esperar el resultado antes de iniciar tratamiento

B Traslado a UCI e inicio inmediato de tratamiento multimodal, más antibióticos para la neumonía

C Solicitar cintigrama tiroideo para confirmar la etiología

D Aumentar el tiamazol y controlar en 48 horas en sala

E Administrar radioyodo en dosis ablativa

Respuesta B. Burch-Wartofsky de 75 puntos (≥ 45): tormenta tiroidea desencadenada por una neumonía. El diagnóstico es clínico y el tratamiento no se retrasa por exámenes: UCI, propranolol, PTU, Lugol 1 hora después del PTU, hidrocortisona EV, paracetamol y medidas físicas, reanimación y antibióticos empíricos.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 50 años con hipertiroidismo de Graves no controlado consulta en urgencias por fiebre de 39,5 °C, agitación psicomotora, náuseas, vómitos profusos y palpitaciones. ECG: taquicardia sinusal a 145 lpm. Escala de Burch-Wartofsky: 60 puntos. **¿Cuál de las siguientes secuencias y combinaciones de fármacos representa el manejo médico correcto?**

A Ácido acetilsalicílico 1 g EV de inmediato, seguido de tiamazol 10 mg oral

B Propranolol, propiltiouracilo a dosis altas, hidrocortisona EV y solución de Lugol al menos una hora después del propiltiouracilo

C Solución de Lugol en bolo endovenoso inmediato y levotiroxina en infusión

D Tiroidectomía total de urgencia en los primeros 30 minutos sin fármacos previos

E Radioyodo a dosis máxima como terapia ablativa urgente

Respuesta B. Tratamiento multimodal: betabloqueo, PTU (bloquea síntesis y conversión periférica), hidrocortisona EV (insuficiencia suprarrenal relativa) y Lugol diferido al menos 1 hora tras el PTU para evitar el efecto Jod-Basedow. Los salicilatos están contraindicados.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En un paciente cursando una tormenta tiroidea con hipertermia de 40,2 °C y compromiso sensorial en la unidad de cuidados intensivos, el residente de turno planea indicar un antipirético. **¿Cuál de los siguientes antipiréticos está formalmente contraindicado por el riesgo de aumentar la hormona tiroidea libre?**

A Paracetamol

B Dipirona (metamizol)

C Ácido acetilsalicílico (aspirina)

D Ibuprofeno

E Ketorolaco

Respuesta C. Los salicilatos desplazan a la T4 y la T3 de la TBG y la transtiretina, aumentando bruscamente la fracción libre y agravando la tormenta. El antipirético de elección es el paracetamol con medidas físicas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años con enfermedad de Graves en abandono de tratamiento ingresa a urgencias con shock distributivo, agitación extrema, diaforesis, ictericia y fibrilación auricular rápida a 160 lpm. Burch-Wartofsky: 65 puntos. **¿Cuál es el fundamento fisiopatológico principal para administrar hidrocortisona endovenosa en el esquema inicial?**

A Tratar la insuficiencia suprarrenal relativa por metabolismo acelerado del cortisol y frenar la conversión periférica de T4 a T3

B Inducir inmunosupresión inmediata de los TRAb en menos de 2 horas

C Elevar la TSH hipofisaria y restablecer el asa de retroalimentación

D Favorecer la captación folicular de yodo inorgánico

E Evitar la hipoglicemia provocada por el propiltiouracilo

Respuesta A. El hipermetabolismo acelera la degradación del cortisol y supera la reserva suprarrenal (insuficiencia suprarrenal relativa). La hidrocortisona a dosis de estrés previene el colapso hemodinámico y además inhibe la desyodasa periférica, frenando la conversión de T4 a T3.

▶ VER CLASE 1.03.2.002 **Mixedema** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 1.3 · Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas

QUÉ HAY QUE SABER

- Coma mixedematoso: hipotiroidismo grave no tratado o abandonado más un gatillante (frío invernal, infección, sedantes u opioides, ACV o infarto); típico en mujer de edad avanzada; mortalidad 30–50 %.
- Clínica: hipotermia <35 °C (termómetro rectal), sopor o coma, bradicardia, hipotensión refractaria a volumen e hipoventilación con hipercapnia; hiponatremia, hipoglicemia, CK alta y anemia.
- Confirmación: TSH muy alta (>50–100) con T4 libre indetectable (TSH baja si es central), pero el tratamiento no espera el resultado.
- Hidrocortisona 100 mg EV en bolo y luego 100 mg c/8 h antes o junto con levotiroxina EV de carga 300–500 mcg y luego 50–100 mcg/día (vía oral no sirve por íleo).
- Soporte: recalentamiento pasivo (no activo), intubación si hay hipercapnia, restricción hídrica (NaCl 3 % si Na <120 sintomático), y buscar y tratar el gatillante con cultivos y antibióticos. Derivar a UCI.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 153

Paciente con piel seca, bradicardia, hipotensión, compromiso de conciencia, TSH 100 y T4 libre muy baja. **¿Diagnóstico?**

A Coma mixedematoso

B Hipotiroidismo subclínico severo

C Insuficiencia suprarrenal aguda

D Encefalopatía hipoglucémica

E Hipotiroidismo primario descompensado

Respuesta A. Hipotiroidismo grave (TSH 100, T4 libre muy baja) con compromiso de conciencia, bradicardia e hipotensión: coma mixedematoso. El compromiso de conciencia y la inestabilidad hemodinámica lo separan de un hipotiroidismo descompensado sin urgencia vital.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 30

Una paciente de 46 años, con antecedentes de anemia perniciosa y vitíligo, es traída al servicio de urgencia por un cuadro de malestar general y desorientación. Sus familiares relatan que ha presentado compromiso del estado general y astenia de 3 semanas de evolución, asociando recientemente a somnolencia y desorientación. Al examen físico está en sopor superficial y sus signos vitales muestran presión arterial: 90/60 mmHg, frecuencia cardíaca: 62 lpm, temperatura: 36 °C. En el examen segmentario se objetiva lengua de gran tamaño y edema de extremidades inferiores. Al examen neurológico está soporosa, no tiene focalidad neurológica y se observa enlentecimiento de la fase de relajación de los reflejos osteotendíneos. Los exámenes de laboratorio muestran sodio: 130 mEq/L, hemoglobina: 10 g/dl, hematocrito: 31%, VCM 102 fL, glóbulos blancos: 5.200/mm³ y plaquetas: 180.000/mm³. Se solicita TAC de cerebro, que no muestra alteraciones. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A Suero hipertónico endovenoso
B Suero fisiológico endovenoso
C Levotiroxina endovenosa
D Corticoides endovenosos
E Antibióticos endovenosos

Respuesta D. Coma mixedematoso en una tiroiditis autoinmune (vitíligo y anemia perniciosa sugieren autoinmunidad poliglandular). La primera medida son los corticoides EV, seguidos de la levotiroxina EV: darla sola puede precipitar una insuficiencia suprarrenal aguda.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 78 años con hipotiroidismo en abandono de tratamiento, encontrada inconsciente en su casa durante una ola de frío. En urgencia: coma, piel fría y engrosada, temperatura rectal 31,8 °C, FC 42 lpm, PA 80/50 mmHg, FR 8 rpm. Glicemia 55 mg/dL, Na 118 mEq/L, acidosis respiratoria hipercápnica, TSH > 100 mUI/L y T4 libre indetectable. **Además de intubarla, ¿cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Levotiroxina 500 mcg EV y esperar el cortisol sérico antes de dar corticoides
B Hidrocortisona 100 mg EV antes o junto con la carga de levotiroxina EV, y recalentamiento pasivo
C Baño de inmersión en agua caliente y levotiroxina oral
D Hemodiálisis de urgencia por la hiponatremia
E Levotiroxina 25 mcg oral y subir lentamente cada 6 semanas

Respuesta B. Coma mixedematoso gatillado por frío: hipotermia, coma, bradicardia, hipotensión, hipoventilación, hiponatremia e hipoglicemia. Se da hidrocortisona 100 mg EV antes o junto con la levotiroxina EV de carga, sin esperar el cortisol, con recalentamiento pasivo.

▶ VER CLASE **1.03.2.003** **Insuficiencia suprarrenal aguda** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.13 · Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario

QUÉ HAY QUE SABER

- Crisis suprarrenal: shock desproporcionado y refractario a volumen y noradrenalina, compromiso de conciencia, dolor abdominal y vómitos (simula abdomen agudo), a veces fiebre.
- Gatillantes: infección intercurrente (la causa n.º 1), gastroenteritis con vómitos, suspensión brusca de corticoides o no subir la dosis ante estrés, cirugía o trauma; debut por hemorragia suprarrenal bilateral (Waterhouse-Friderichsen en meningococcemia, antifosfolípido).
- Laboratorio: hiponatremia, hiperkalemia (solo en la primaria), hipoglicemia, acidosis metabólica y azoemia prerrenal. Tomar cortisol, ACTH y electrolitos pero no esperar el resultado.
- Tratamiento: hidrocortisona 100 mg EV en bolo en el minuto cero, suero fisiológico 1–2 L en las primeras 2 h y suero glucosado para la hipoglicemia; dexametasona 4–6 mg EV si no hay hidrocortisona.
- Mantención: hidrocortisona 50 mg c/6 h (o 200 mg/24 h) por 24–48 h y descenso gradual a vía oral; fludrocortisona solo en Addison al bajar de 50 mg/día. Buscar y tratar el gatillante (cultivos, antibióticos). Seguimiento: derivar a endocrinología y educar dosis de estrés.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 20

Un paciente tiene diarrea de 3 días de evolución, asociada a malestar general marcado y vómitos alimentarios, con deterioro del estado general. Al examen físico se observa deshidratado, con FC: 110 x', PA: 70/40 mmHg, abdomen doloroso, sin irritación peritoneal. Se solicitan exámenes, entre los que destacan Na+: 126 mEq/L, K+: 4,7 mEq/L, glicemia: 58 mg/dl, PCR: 4,0, blancos: 12.000 por mm3, creatinina 2,3 mg/dl. Se administran 3 litros de suero fisiológico, sin lograr estabilizar al paciente. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Insuficiencia renal aguda
B Shigelosis
C Peritonitis aguda
D Insuficiencia suprarrenal aguda
E Accidente vascular hemorrágico

Respuesta D. Shock refractario a 3 litros de suero, hiponatremia, hipoglicemia y potasio en el límite alto, con dolor abdominal sin irritación peritoneal: crisis suprarrenal clásica. La creatinina elevada es azoemia prerrenal por hipoperfusión, no el diagnóstico principal.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 39 años con enfermedad de Addison en tratamiento con hidrocortisona y fludrocortisona. Hace 48 horas inicia vómitos y diarrea, sin tolerar sus comprimidos. Llega soporoso, febril (38,8 °C), PA 70/40 mmHg, FC 130 lpm, con dolor abdominal difuso sin peritonismo e hiperpigmentación en manos y mucosa oral. HGT 48 mg/dL. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Solicitar cortisol plasmático y ACTH, y tratar según resultado

B Hidrocortisona 100 mg EV en bolo + suero fisiológico y suero glucosado

C Iniciar noradrenalina y solicitar TAC de abdomen

D Fludrocortisona oral y aumentar la hidrocortisona oral al doble

E Laparotomía exploradora por abdomen agudo

Respuesta B. Crisis suprarrenal gatillada por gastroenteritis con intolerancia oral: shock, compromiso de conciencia, dolor abdominal e hipoglicemia. Se trata de inmediato con hidrocortisona 100 mg EV en bolo, suero fisiológico y suero glucosado, sin esperar exámenes. La fludrocortisona no se usa en la fase aguda y la vía oral no sirve con vómitos.

▶ VER CLASE 1.03.2.004 Hipercalcemia aguda

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.16 · Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante calcio corregido ≥12–14 mg/dL con poliuria, deshidratación, náuseas, vómitos, constipación, debilidad, confusión o estupor, arritmias y QT corto; causas principales: neoplasias (PTHrP, osteólisis) e hiperparatiroidismo primario.
- Severidad: leve <12 (hidratación oral), moderada 12–13,9 (hospitalizar), crisis ≥14 o con compromiso neurológico, arritmias o falla renal (UCI).
- Primer pilar: suero fisiológico 0,9 % 200–300 mL/h (2–4 L en 24 h); furosemida solo una vez euvolémico o con sobrecarga, nunca antes de hidratar.
- Ácido zoledrónico 4 mg EV en 15 min (efecto en 48–72 h) y calcitonina de salmón como puente (actúa en 4–6 h); corticoides si es por linfoma, mieloma, sarcoidosis o exceso de vitamina D; hemodiálisis si hay falla renal refractaria.
- Pedir PTH antes de tratar para orientar la causa. Seguimiento: derivar para estudio etiológico (búsqueda de cáncer o paratiroidectomía).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 123

Un paciente de 76 años, con antecedente de cáncer de próstata avanzado, presenta un cuadro de 2 días de evolución de debilidad y malestar general, al que se agrega obnubilación de conciencia y tendencia al sopor. Al examen físico se aprecia desorientado, con sopor profundo, sin focalidad neurológica, tiene FC: 80x', PA: 150/100 mmHg y FR: 16x'. El examen torácico y abdominal no aporta mayor información. Se solicitan electrolitos plasmáticos que muestran sodio: 148 mEq/L, potasio: 5 mEq/L, calcio: 14,8 mg/dl y otros exámenes de sangre que muestran creatinina: 1,4 mg/dl, GOT: 50 UI/l, 2, APE: 200 ng/ml. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Administrar calcitonina endovenosa

B Realizar hemodiálisis de urgencia

C Administrar ácido zolendrónico endovenoso

D Administrar gluconato de calcio endovenoso

E Administrar suero fisiológico endovenoso

Respuesta E. Calcio de 14,8 mg/dL con sopor: crisis hipercalcémica maligna. La primera medida es la expansión de volumen con suero fisiológico, que restaura la filtración e induce calciuresis. El zoledronato va después (demora 48–72 h y requiere hidratación previa); la calcitonina es puente; la hemodiálisis se reserva para falla renal anúrica o refractariedad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 79

Hombre de 55 años con hipercalcemia severa (Ca 13.5 mg/dL), náuseas, poliuria, confusión y deshidratación. PTH elevada. **¿Cuál es el tratamiento inicial de urgencia?**

A Resonancia magnética

B Cintigrafía con sestamibi (localización de adenoma paratiroideo)

C Hidratación EV con solución salina 0.9%

D Paratiroidectomía de urgencia

E Carbonato de calcio oral

Respuesta C. Hipercalcemia sintomática con deshidratación: el tratamiento de urgencia es la hidratación EV con suero fisiológico al 0,9 %, aunque la causa sea un hiperparatiroidismo. El sestamibi y la paratiroidectomía se planifican de forma electiva, una vez estabilizado.

▶ VER CLASE 1.03.2.005 Tetania

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.17 · Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Tetania por hipocalcemia (calcio corregido <8,5 o iónico <4,0 mg/dL): causa n.º 1 el hipoparatiroidismo 24–72 h post tiroidectomía; también hipomagnesemia severa, pancreatitis, sepsis y transfusión masiva.

- Clínica: parestesias periorales y distales (signo más precoz), espasmo carpopedal, hiperreflexia, laringoespasmo con estridor y convulsiones; signos de Chvostek y Trousseau (más sensible y específico); ECG con QT prolongado.
- Tratamiento: gluconato de calcio 10 % 1–2 ampollas EV en 10–20 min con monitor, seguido de infusión (10 ampollas en 1.000 mL de SG 5 %); preferir gluconato a cloruro por riesgo de necrosis si se extravasa.
- Si no responde: medir y reponer magnesio (sulfato de magnesio 1–2 g EV en 20 min); sin magnesio no se secreta ni actúa la PTH.
- Mantención en hipoparatiroidismo: carbonato de calcio 1–3 g/día con las comidas + calcitriol 0,25–1 mcg/día (el colecalciferol no sirve), meta de calcio 8,0–8,5. Seguimiento: derivar a endocrinología.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 82

Una mujer de 29 años, con antecedente de tiroidectomía por cáncer de tiroides hace 5 meses, consulta por síntomas de una semana de evolución, consistentes en astenia, nerviosismo y palpitaciones, que han ido en aumento. Además, el día de hoy presentó convulsiones en una oportunidad, por lo que fue traída al Servicio de Urgencia. Al examen físico está en Glasgow 15, sin convulsiones actuales ni focalidad neurológica. Se solicitan exámenes de laboratorio, entre los que destacan glicemia: 120 mg/dl, potasemia: 4,0 mEq/l, natremia: 144 mEq/L, calcemia 6,3 mg/dl, fósforo: 5,5 mg/dl, albúmina: 3,9 g/dl y hematocrito: 48%. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada en esta paciente?**

A Administrar suero fisiológico
B Solicitar TAC de cerebro
C Administrar calcio endovenoso
D Administrar lorazepam endovenoso
E Administrar calcitonina

Respuesta C. Tiroidectomía reciente, calcio bajo con fósforo alto y albúmina normal: hipocalcemia por hipoparatiroidismo postquirúrgico, sintomática (convulsión). La conducta inicial es gluconato de calcio endovenoso.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 110

Paciente con tiroidectomía total e hipoparatiroidismo, presenta debilidad, parestesias y signo de Chvostek positivo. **¿Cuál es el tratamiento inicial?**

A Calcitriol oral más calcio oral
B Gluconato de calcio endovenoso
C Carbonato de calcio 1 g oral
D PTH recombinante subcutáneo
E Terlipresina endovenosa

Respuesta B. Parestesias con Chvostek positivo en un paciente sin paratiroides: hipocalcemia sintomática. El tratamiento inicial es gluconato de calcio EV. El calcio oral con calcitriol es el tratamiento de mantención, no el rescate.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 25

Un paciente, con antecedente de tiroidectomía total e hipoparatiroidismo, en tratamiento con levotiroxina, calcio y vitamina D, por vía oral, presenta diarrea aguda, de 2 días de evolución, abundante. Evoluciona con astenia, marcada debilidad, dolor en las extremidades inferiores y calambres. Al examen físico tiene reflejos osteotendíneos vivos y signo de Chvostek positivo. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Suero fisiológico endovenoso
B Gluconato de calcio endovenoso
C Suero glucosado con potasio endovenoso
D Suero Ringer endovenoso
E Hidrocortisona endovenosa

Respuesta B. Un hipoparatiroideo que depende del calcio oral deja de absorberlo con la diarrea y cae en hipocalcemia sintomática: calambres, hiperreflexia y Chvostek positivo. Conducta inicial: gluconato de calcio EV.

Conocimientos generales

3 códigos

▶ VER CLASE **1.03.3.001** **Pubertad normal**

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.1 · Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

QUÉ HAY QUE SABER

- En niñas la pubertad normal comienza entre los 8 y 13 años; el primer signo es la telarquia (botón mamario, puede ser unilateral y sensible), seguida de pubarquia, estirón puberal y menarquia unos 2 años después de la telarquia.
- En niños comienza entre los 9 y 14 años; el primer signo es el aumento del volumen testicular (≥4 mL), luego pubarquia, crecimiento del pene y el estirón, que en ellos es más tardío.
- Se evalúa con los estadios de Tanner (mamas o genitales y vello púbico) y la curva de talla y velocidad de crecimiento.
- Pubertad precoz: antes de los 8 años en niñas y de los 9 en niños, derivar a endocrinología infantil. Retraso puberal: sin telarquia a los 13 años en niñas o sin aumento testicular a los 14 en niños.
- Variantes normales que no requieren estudio: telarquia prematura aislada en lactantes, ginecomastia puberal transitoria en varones adolescentes.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una niña de 10 años es llevada a control porque la madre notó un 'bultito' bajo la areola derecha hace 2 meses, levemente sensible. No tiene vello púbico ni ha menstruado. Su crecimiento es normal. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Pubertad precoz que requiere estudio urgente

B Tumor mamario que requiere biopsia

C Inicio normal de la pubertad: la telarquia es el primer signo puberal en las niñas

D Ginecomastia

E Hiperprolactinemia

Respuesta C. En niñas la pubertad normal comienza entre los 8 y 13 años, y su primer signo es la telarquia (botón mamario), que puede ser unilateral y sensible al inicio. Luego vienen pubarquia, estirón y menarquia. En niños el primer signo es el aumento testicular (≥4 mL). Pubertad precoz en niñas es antes de los 8 años.

▶ VER CLASE 1.03.3.002 Prevención de osteoporosis

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.18 · Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Prevención para toda la población, sobre todo mujeres posmenopáusicas: calcio 1.000–1.200 mg/día idealmente con la dieta (lácteos) y vitamina D suficiente (800–2.000 UI/día si hay déficit o poca exposición solar).
- Ejercicio con carga y de fuerza, suspender el tabaco, moderar el alcohol (<3 unidades/día) y mantener un IMC >20.
- Prevención de caídas en adultos mayores: revisar fármacos sedantes, corregir la visión, adaptar el hogar y entrenar el equilibrio.
- Osteopenia con FRAX bajo no requiere fármacos: medidas generales y DEXA de control en 2–3 años. Tamizaje con DEXA en mujeres ≥65 años o con factores de riesgo.
- Usuarios de corticoides crónicos: dosis mínima eficaz, calcio y vitamina D, y evaluar bifosfonato si reciben prednisona ≥5–7,5 mg/día por más de 3 meses.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 54 años, menopáusica hace 3 años, fumadora de 10 cigarrillos al día, sedentaria, IMC 21. Ingiere un solo lácteo al día. Sin fracturas previas ni uso de corticoides. Su densitometría muestra T-score −1,4 en columna y −1,2 en cadera, con riesgo de fractura a 10 años bajo según FRAX. **¿Cuál es la indicación más adecuada?**

A Alendronato 70 mg semanal

B Asegurar 1.000–1.200 mg/día de calcio, idealmente con la dieta, vitamina D, ejercicio con carga, suspender el tabaco y moderar el alcohol

C Ácido zoledrónico anual

D Solo control densitométrico en 6 meses

E Calcitonina nasal

Respuesta B. Osteopenia con riesgo de fractura bajo: no tiene indicación de fármacos antirresortivos. Corresponde la prevención: aporte de calcio de 1.000–1.200 mg/día, idealmente con la dieta, vitamina D suficiente, ejercicio con carga y de fuerza, dejar el tabaco, moderar el alcohol y prevenir caídas. La densitometría de control se repite en 2 a 3 años, no a los 6 meses.

▶ VER CLASE 1.03.3.003 Complicaciones del tratamiento esteroidal

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.13 · Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario

QUÉ HAY QUE SABER

- Supresión del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal con dosis suprafisiológicas por más de 3 semanas: la suspensión brusca causa insuficiencia suprarrenal aguda (hipotensión, vómitos, hiponatremia); retirar siempre en forma gradual y dar dosis de estrés ante enfermedad o cirugía.
- Cushing iatrogénico: obesidad central, cara de luna, estrías, equimosis, miopatía proximal, HTA, hiperglicemia o diabetes y dislipidemia.
- Osteoporosis inducida por corticoides (la causa secundaria más frecuente): calcio, vitamina D y bifosfonato si prednisona ≥5–7,5 mg/día por más de 3 meses; también necrosis avascular de cadera.
- Infecciones (incluida reactivación de TBC: tamizar antes de dosis altas prolongadas), úlcera péptica con AINE, cataratas, glaucoma, alteraciones psiquiátricas (euforia, insomnio, psicosis) y retraso del crecimiento en niños.
- Prevención: dosis mínima eficaz por el menor tiempo posible, preferir vía local (inhalada, tópica, intraarticular) y vigilar PA, glicemia, densitometría y presión ocular.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 60 años usa prednisona 20 mg/día desde hace 8 meses por una enfermedad pulmonar intersticial. Suspendió el fármaco bruscamente hace 4 días por miedo a sus efectos adversos. Consulta por náuseas, vómitos y debilidad intensa. PA 80/50 mmHg, natremia 131 mEq/L. **¿Cuál es la complicación más probable y su manejo?**

A Síndrome de Cushing: suspender corticoides

B Hipotiroidismo: levotiroxina

C Hiperaldosteronismo: espironolactona

D Feocromocitoma: bloqueo alfa

E Insuficiencia suprarrenal aguda secundaria por supresión del eje: hidrocortisona endovenosa y volumen

Respuesta E. Los corticoides en dosis suprafisiológicas por más de 3 semanas suprimen el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, y su suspensión brusca puede causar insuficiencia suprarrenal aguda. Se trata con hidrocortisona endovenosa (100 mg en bolo) y suero fisiológico, sin esperar exámenes. Por eso los corticoides prolongados se retiran en forma gradual.

Exámenes e imagenología

11 códigos

▶ VER CLASE 1.03.4.001 **Ecografía tiroídea** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.9 · Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: nódulo palpable o incidental, bocio, adenopatías cervicales, seguimiento de nódulos y de cáncer de tiroides operado.
- Es el examen que estratifica el riesgo del nódulo mediante TI-RADS; no reemplaza la TSH, que va primero.
- Hallazgos de alta sospecha (TR5): sólido, marcadamente hipoecogénico, más alto que ancho, márgenes irregulares o extensión extratiroidea, microcalcificaciones. Benignidad: espongiforme o quiste simple anecoico.
- Conducta según informe: PAAF guiada en TR3 ≥2,5 cm, TR4 ≥1,5 cm y TR5 ≥1 cm; bajo el umbral, seguimiento ecográfico; TR1–TR2 no se punciona.
- Otros hallazgos: Hashimoto da tiroides heterogénea e hipoecogénica; Graves, glándula aumentada e hipervascular; adenopatías sospechosas obligan a PAAF del ganglio y derivación.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 44 años, eutiroidea (TSH 1,8 mUI/L), sin antecedentes de radiación. Se palpa un nódulo en el lóbulo izquierdo. La ecografía tiroidea muestra un nódulo sólido de 1,3 cm, marcadamente hipoecogénico, más alto que ancho, de bordes irregulares y con microcalcificaciones, sin adenopatías cervicales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Control ecográfico en 12 meses, porque mide menos de 2 cm

B Iniciar levotiroxina para frenar el crecimiento

C Cintigrafía tiroidea

D Tiroidectomía total sin estudio citológico

E Punción aspirativa con aguja fina guiada por ecografía

Respuesta E. La ecografía es el examen que estratifica el riesgo del nódulo. Hipoecogenicidad marcada, forma más alta que ancha, bordes irregulares y microcalcificaciones son signos de sospecha alta (TI-RADS 5): se indica PAAF desde 1 cm. La cintigrafía solo se pide con TSH baja, y no se opera sin citología.

▶ VER CLASE 1.03.4.002 **Densitometría ósea** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.18 · Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- DEXA axial (columna L1–L4 y cadera) es el estándar de oro para la densidad mineral ósea; se compara con el adulto joven (T-score) y con la misma edad (Z-score).
- T-score (posmenopáusicas y hombres ≥50 años): ≥ −1,0 normal; entre −1,0 y −2,5 osteopenia; ≤ −2,5 osteoporosis (basta un sitio); con fractura por fragilidad, osteoporosis severa.
- Z-score (premenopáusicas y hombres <50 años): ≤ −2,0 = densidad baja para la edad, obliga a buscar causa secundaria (corticoides, hipogonadismo, celiaquía, hiperparatiroidismo).
- Indicaciones: mujeres ≥65 años, posmenopáusicas o hombres mayores con factores de riesgo, corticoides crónicos, fractura por fragilidad y control del tratamiento cada 1–2 años.
- Osteopenia: calcular FRAX (tratar si ≥20 % fractura mayor o ≥3 % cadera). Una fractura por fragilidad se trata aunque la DEXA no llegue a −2,5.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 38 años, con menstruaciones regulares, en tratamiento con prednisona 10 mg/día hace 14 meses por lupus. Se solicita densitometría ósea (DEXA): columna lumbar T-score −2,7 y Z-score −2,4; cuello femoral T-score −2,1 y Z-score −2,0. No tiene fracturas. **¿Cuál es la interpretación correcta de la densitometría?**

A Osteoporosis, porque el T-score es menor de −2,5

B Osteopenia, porque el cuello femoral está sobre −2,5

C Densitometría normal

D Densidad mineral ósea baja para la edad, según el Z-score, que es el índice que se usa en mujeres premenopáusicas

E Osteoporosis severa

Respuesta D. El T-score compara con el adulto joven y diagnostica osteoporosis (≤ −2,5) en posmenopáusicas y hombres de 50 años o más. En premenopáusicas y hombres menores de 50 se usa el Z-score, que compara con la misma edad: ≤ −2,0 es densidad baja para la edad y obliga a buscar una causa secundaria, aquí los corticoides.

▶ VER CLASE 1.03.4.003

TSH, T4, T3

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 1.1 · Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo
Endocrinología 1.2 · Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina
Endocrinología 7.6 · Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos

QUÉ HAY QUE SABER

- La TSH ultrasensible es el examen inicial de elección ante cualquier sospecha tiroidea (VN adulto 0,4–4,5 mUI/L); pequeños cambios de T4 libre producen grandes cambios de TSH. Siempre interpretar junto a la T4 libre.
- Patrones: TSH alta y T4L baja = hipotiroidismo primario; TSH alta y T4L normal = subclínico; TSH <0,1 y T4L o T3 alta = hipertiroidismo; T4L baja con TSH baja o normal = hipotiroidismo central (RM de hipófisis y descartar insuficiencia suprarrenal).
- TSH suprimida con T4L normal y clínica de tirotoxicosis: medir T3 (T3-toxicosis, típica del adenoma tóxico y del bocio multinodular); si también es normal, hipertiroidismo subclínico.
- La T4 total se eleva con estrógenos (anticonceptivos, embarazo) por aumento de la TBG sin cambiar la hormona libre; preferir T4 libre.
- Paciente crítico con T3 baja, T3 reversa alta y TSH y T4L normales o bajas: eutiroideo enfermo; no tratar con levotiroxina y repetir el perfil semanas después del alta. Embarazo: metas de TSH <2,5 en el 1.er trimestre y <3,0 después.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 66 años en UCI por shock séptico de foco pulmonar, intubado y con noradrenalina. Perfil tiroideo de ingreso: TSH 0,6 mUI/L (VN 0,4–4,0), T4 libre 0,82 ng/dL (VN 0,8–1,8), T3 total 35 ng/dL (VN 80–200) y T3 reversa muy elevada. Sin antecedentes de patología tiroidea ni bocio. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto del eje tiroideo?**

A Iniciar levotiroxina endovenosa en dosis sustitutiva completa

B Iniciar T3 (liotironina) por sonda nasogástrica

C Observar el eje tiroideo, tratar la sepsis y repetir el perfil semanas después del alta

D Solicitar resonancia de hipófisis por hipotiroidismo central

E Iniciar hidrocortisona y luego levotiroxina

Respuesta C. Paciente crítico con T3 muy baja, T3 reversa alta y TSH y T4 libre normales: síndrome del eutiroideo enfermo. Es una respuesta adaptativa; la levotiroxina y la T3 están contraindicadas. Se trata la sepsis y se reevalúa el perfil semanas después del alta.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años operada hace 8 meses de un macroadenoma hipofisario no funcionante. Consulta por astenia, intolerancia al frío y constipación. FC 58 lpm, piel seca. Exámenes: TSH 0,9 mUI/L (VN 0,4–4,0), T4 libre 0,45 ng/dL (VN 0,8–1,8). Cortisol plasmático matinal normal. **¿Cuál es la interpretación y conducta más adecuada?**

A Hipotiroidismo central; iniciar levotiroxina y controlar con T4 libre

B Hipotiroidismo primario; ajustar la levotiroxina según la TSH

C Eje tiroideo normal, porque la TSH es normal

D Síndrome del eutiroideo enfermo; repetir en 6 semanas

E Hipertiroidismo subclínico; observar

Respuesta A. Una T4 libre baja con TSH normal o baja, no elevada, indica hipotiroidismo central, aquí por daño hipofisario. La TSH deja de servir para el control: la levotiroxina se ajusta con la T4 libre, buscando la mitad superior del rango normal. Antes de iniciarla debe descartarse insuficiencia suprarrenal, ya resuelto en este caso.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años con palpitaciones, temblor fino y baja de 5 kg en 2 meses. FC 112 lpm, nódulo tiroideo palpable de 3 cm en el lóbulo derecho. Exámenes: TSH 0,01 mUI/L (VN 0,4–4,0), T4 libre 1,6 ng/dL (VN 0,8–1,8). **¿Cuál es el examen más adecuado para completar la evaluación de la función tiroidea?**

A Repetir la TSH en 6 semanas, ya que la T4 libre es normal

B Solicitar anticuerpos antitiroperoxidasa

C Solicitar T3 total o libre

D Solicitar tiroglobulina

E Solicitar T3 reversa

Respuesta C. TSH suprimida con T4 libre normal en un paciente con clínica de tirotoxicosis obliga a medir la T3: probable T3-toxicosis, frecuente en el adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico. Si la T3 también es normal, se trata de un hipertiroidismo subclínico. Luego la cintigrafía define la etiología.

▶ VER CLASE 1.03.4.004 T4 libre

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 1.1 · Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo

QUÉ HAY QUE SABER

- Mide la hormona libre activa, sin influencia de la TBG (estrógenos, embarazo); complementa a la TSH y define el tipo de falla.
- T4 libre baja con TSH alta: hipotiroidismo primario clínico; T4L normal con TSH alta: subclínico; T4L alta con TSH suprimida: hipertiroidismo clínico.
- T4 libre baja con TSH baja o inapropiadamente normal: hipotiroidismo central (adenoma hipofisario, Sheehan, cirugía o radioterapia); antes de dar levotiroxina descartar insuficiencia suprarrenal.
- En el hipotiroidismo central y tras tiamazol inicial el control se hace con T4 libre (meta: mitad superior del rango normal), no con TSH, que tarda en recuperarse.
- En el paciente crítico puede bajar sin enfermedad tiroidea (eutiroideo enfermo): no tratar y reevaluar tras la recuperación.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 33

Una paciente de 25 años acude a chequeo médico. Como antecedente, usa suplementos de vitamina D y anticonceptivos orales. Los exámenes de laboratorio muestran T4 total de 16 ng/mL (valor normal 5 a 12) y TSH de 0,9 mU/L (valor normal 0,5 a 5). El examen físico es normal. **¿Qué examen es el más adecuado para proseguir el estudio?**

A Anticuerpos anti-receptor de TSH

B Cintigrafía tiroidea

C Triyodotironina (T3)

D T4 libre

E Tiroglobulina

Respuesta D. Los estrógenos (anticonceptivos, embarazo) elevan la globulina fijadora de tiroxina (TBG), por lo que la T4 total sube sin que cambie la hormona activa. La TSH normal ya descarta hipertiroidismo; si se quiere completar, se mide la T4 libre, que no depende de la TBG.

▶ VER CLASE 1.03.4.005 Anticuerpos antitiroideos (antitiroglobulina y antiiroperoxidasa)

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 1.2 · Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina

QUÉ HAY QUE SABER

- Anti-TPO (antiperoxidasa) y anti-Tg (antitiroglobulina) marcan autoinmunidad tiroidea: positivos en más del 90 % de los Hashimoto.
- En el hipotiroidismo subclínico, anti-TPO positivos duplican el riesgo de progresión a hipotiroidismo clínico (cerca de 4 % al año) y apoyan tratar con TSH 4,5–9,9, sobre todo en embarazo o deseo de embarazo.
- Tiroiditis posparto y silente: anti-TPO positivos en 50–70 %, con mayor riesgo de hipotiroidismo definitivo; la De Quervain no es autoinmune (VHS alta, anticuerpos negativos).
- Los anti-Tg se piden siempre junto con la tiroglobulina en el seguimiento del cáncer diferenciado, porque la falsean hacia abajo.
- No confundir con TRAb (anticuerpos contra el receptor de TSH), que son los que confirman Graves.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 32 años, asintomática, tiene TSH de 7,2 µUI/mL con T4 libre normal, confirmados en 2 mediciones. No está embarazada ni lo planifica. **¿Qué examen ayuda más a estimar el riesgo de progresión a hipotiroidismo clínico?**

A Anticuerpos antiperoxidasa tiroidea (anti-TPO)

B Tiroglobulina

C Cintigrama tiroideo

D T3 total

E Calcitonina

Respuesta A. En el hipotiroidismo subclínico, los anticuerpos anti-TPO positivos indican tiroiditis de Hashimoto y aproximadamente duplican el riesgo de progresión a hipotiroidismo clínico (cerca de 4% al año). Ayudan a decidir tratamiento y frecuencia de controles. La tiroglobulina es marcador tumoral del cáncer diferenciado tratado, y la calcitonina del carcinoma medular.

▶ VER CLASE 1.03.4.006 Cortisol plasmático

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 7.11 · Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico
Endocrinología 7.12 · Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia suprarrenal: cortisol plasmático a las 8 h <3 mcg/dL confirma, >15–18 la descarta; entre 3 y 15 es indeterminado y requiere test de Synacthen 250 mcg (pico <18 confirma).
- En la crisis suprarrenal se toma la muestra pero no se espera el resultado para dar hidrocortisona.
- Cushing: un cortisol matinal aislado no diagnostica ni descarta (está en su peak fisiológico); se usa en el test de Nugent (cortisol 8 h tras 1 mg de dexametasona, normal <1,8 mcg/dL).
- Los estrógenos (anticonceptivos, embarazo) elevan la CBG y el cortisol total, dando falsos positivos en el Nugent; en ese caso usar cortisol libre urinario.
- No sirve para ajustar la dosis de hidrocortisona en el paciente con reemplazo; tras confirmar alteración, la ACTH define el origen.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 46 años con obesidad, hipertensión y DM2 de difícil control. Su médico sospecha síndrome de Cushing y solicita un cortisol plasmático a las 8 h, que resulta 21 mcg/dL (VN 5–25). Al examen no tiene estrías violáceas, miopatía proximal ni equimosis. **¿Cuál es la interpretación más adecuada de este resultado?**

A Descarta el síndrome de Cushing

B No sirve para el tamizaje; se debe solicitar test de Nugent, cortisol libre urinario de 24 horas o cortisol salival nocturno

C Confirma el síndrome de Cushing

D Indica insuficiencia suprarrenal relativa

E Obliga a solicitar TC de suprarrenales

Respuesta B. Un cortisol plasmático matinal aislado no diagnostica ni descarta Cushing: en la mañana el cortisol normal está en su peak y se superpone con el hipercortisolismo. El Cushing pierde la supresión y el ritmo circadiano, por eso se tamiza con Nugent, cortisol libre urinario o cortisol salival nocturno. El cortisol matinal sirve en la insuficiencia suprarrenal.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años con astenia de 4 meses, baja de 5 kg y mareo al ponerse de pie. PA 100/65 mmHg. Sin hiperpigmentación. Na 134 mEq/L, K 4,4 mEq/L. Cortisol plasmático a las 8 h: 9 mcg/dL. **¿Cuál es el paso siguiente más adecuado?**

A Descartar insuficiencia suprarrenal por cortisol normal

B Test de estimulación con ACTH sintética (Synacthen 250 mcg)

C Iniciar hidrocortisona y fludrocortisona

D Test de supresión con dexametasona 1 mg

E Tomografía computarizada de suprarrenales

Respuesta B. Un cortisol matinal entre 3 y 15 mcg/dL es indeterminado: no confirma ni descarta. Corresponde una prueba de estimulación con Synacthen 250 mcg; un pico menor de 18 mcg/dL confirma la insuficiencia. Luego la ACTH define si es primaria o secundaria.

▶ VER CLASE 1.03.4.007 Cortisol libre 24 horas

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 7.11 · Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico

QUÉ HAY QUE SABER

- Prueba de tamizaje de primera línea para síndrome de Cushing: mide la fracción libre de cortisol filtrada en 24 h.
- Se recomiendan 2 recolecciones con creatininuria para asegurar orina completa; un valor >3 veces el límite superior es muy sugerente.
- No se afecta por los estrógenos (anticonceptivos, embarazo), por lo que se prefiere cuando el test de Nugent puede dar falsos positivos.
- Falsos positivos: pseudo-Cushing (depresión, alcoholismo, obesidad mórbida), alta ingesta de líquidos; falsos negativos con insuficiencia renal o recolección incompleta.

- Se confirma hipercortisolismo con 2 pruebas alteradas (CLU, Nugent o cortisol salival nocturno); recién entonces se mide ACTH y se pide imagen.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 28 años, usuaria de anticonceptivos orales combinados hace 3 años, consulta por aumento de peso, acné e hipertensión reciente. Se sospecha síndrome de Cushing. Test de Nugent (1 mg de dexametasona a las 23 h): cortisol a las 8 h de 3,4 mcg/dL. No es posible suspender los anticonceptivos por 6 semanas. **¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el tamizaje?**

A Cortisol libre urinario de 24 horas

B Cortisol plasmático a las 8 horas

C Repetir el test de Nugent con 2 mg de dexametasona

D ACTH plasmática

E Resonancia magnética de silla turca

Respuesta A. Los estrógenos elevan la globulina transportadora de cortisol (CBG) y el cortisol plasmático total, dando falsos positivos en el test de Nugent. El cortisol libre urinario de 24 horas mide la fracción libre y no se afecta; se piden 2 muestras con creatininuria. La ACTH y la imagen van después de confirmar el hipercortisolismo.

▶ VER CLASE 1.03.4.008 FSH, estradiol y prolactina

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 7.21 · Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica
Ginecología 20.1 · Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

QUÉ HAY QUE SABER

- En amenorrea, tras descartar embarazo con beta-hCG, se piden TSH, prolactina y FSH con estradiol.
- FSH elevada (>25–40 mUI/mL en 2 muestras separadas por 4 semanas) con estradiol bajo en menor de 40 años: insuficiencia ovárica prematura (hipogonadismo hipergonadotropo); en mujer >45 años con amenorrea confirma la menopausia, aunque no se pide de rutina.
- FSH y LH bajas o normales bajas con estradiol bajo: hipogonadismo hipogonadotropo (amenorrea hipotalámica funcional en deportistas o bajo peso, Sheehan, tumor hipofisario, Kallmann).
- Prolactina >25 ng/mL (en ayunas y reposo): descartar fármacos, hipotiroidismo y embarazo; >200 sugiere macroprolactinoma.
- En el SOP el estradiol es normal (test de progesterona positivo) y la relación LH/FSH puede estar aumentada; tomar FSH y estradiol en fase folicular precoz (días 2–5) si hay ciclos.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 34 años con amenorrea secundaria de 7 meses, bochornos, sudoración nocturna y sequedad vaginal. No usa fármacos ni anticonceptivos. Beta-hCG negativa, TSH 2,1 mUI/L, prolactina 14 ng/mL (VN menor de 25). FSH 68 mUI/mL, estradiol 12 pg/mL. Se repite la FSH a las 4 semanas: 72 mUI/mL. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Amenorrea hipotalámica funcional

B Prolactinoma

C Síndrome de Sheehan

D Síndrome de ovario poliquístico

E Insuficiencia ovárica prematura

Respuesta E. En la amenorrea, tras descartar embarazo, se piden TSH, prolactina y FSH con estradiol. FSH elevada (sobre 25–40 mUI/mL en 2 muestras separadas por 4 semanas) con estradiol bajo en una mujer menor de 40 años indica insuficiencia ovárica prematura: hipogonadismo hipergonadotropo. La amenorrea hipotalámica y el Sheehan tienen FSH baja o normal.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 20 años, corredora de fondo, con amenorrea secundaria de 6 meses. Entrena 70 km por semana y bajó 7 kg en el último año; IMC 17,5. Beta-hCG negativa, TSH 1,9 mUI/L, prolactina 11 ng/mL. FSH 2,1 mUI/mL, LH 0,9 mUI/mL, estradiol 14 pg/mL. Prueba de progesterona negativa. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Amenorrea hipotalámica funcional

B Síndrome de ovario poliquístico

C Insuficiencia ovárica prematura

D Síndrome de Asherman

E Hiperprolactinemia

Respuesta A. FSH y LH bajas o normales bajas con estradiol bajo: hipogonadismo hipogonadotropo. En una deportista con bajo peso y déficit energético, la causa es la amenorrea hipotalámica funcional, con riesgo de pérdida de masa ósea. La insuficiencia ovárica tiene FSH alta; el SOP tiene estrógenos normales y prueba de progesterona positiva.

▶ VER CLASE 1.03.4.009 LH, testosterona

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Ginecología 20.7 · Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida

QUÉ HAY QUE SABER

- En el hombre con sospecha de hipogonadismo, la testosterona total matinal confirma y la LH clasifica: LH y FSH altas = hipogonadismo primario (Klinefelter, orquitis, quimioterapia); bajas o inapropiadamente normales = central (prolactinoma, tumor hipofisario, Kallmann).
- Klinefelter (47,XXY): testículos pequeños y firmes, azoospermia, ginecomastia y hábito eunucoide; se confirma con cariograma. Kallmann: gonadotropinas bajas y anosmia.
- Los esteroides anabólicos suprimen LH y FSH y atrofian los testículos.
- En la mujer: testosterona total o libre elevada apoya hiperandrogenismo (SOP); valores muy altos o virilización sugieren tumor ovárico o suprarrenal. La relación LH/FSH puede estar aumentada en el SOP, pero no es criterio diagnóstico.
- Con testosterona baja y LH no elevada en el hombre, pedir prolactina y RM de silla turca.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 28 años consulta por infertilidad conyugal de 2 años. Es alto, con escaso vello corporal, ginecomastia leve y testículos pequeños y firmes (3 mL). El espermiograma muestra azoospermia y la testosterona total es baja (180 ng/dL). **¿Qué resultado de LH y FSH es esperable y cuál es el diagnóstico más probable?**

A LH y FSH bajas: hipogonadismo hipogonadotrópico (Kallmann)

B LH y FSH normales: obstrucción de conductos deferentes

C LH y FSH elevadas: hipogonadismo primario, probable síndrome de Klinefelter

D LH baja y FSH alta: prolactinoma

E LH alta y FSH baja: uso de esteroides anabólicos

Respuesta C. Testículos pequeños y firmes, azoospermia, ginecomastia y hábito eunucoide con testosterona baja y gonadotropinas elevadas (hipogonadismo hipergonadotrópico) sugieren síndrome de Klinefelter (47,XXY), que se confirma con cariograma. En el hipogonadismo central (Kallmann, tumor hipofisario) LH y FSH están bajas o inapropiadamente normales; los anabólicos las suprimen.

▶ VER CLASE 1.03.4.010 PTH, calcemia

NIVEL **INTERPRETA Y EMPLEA**

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.16 · Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico

QUÉ HAY QUE SABER

- Interpretar el calcio corregido por albúmina: calcio + 0,8 × (4 – albúmina); en hipoalbuminemia la calcemia total baja puede ser normal (seudohipocalcemia).
- Hipercalcemia con PTH alta o inapropiadamente normal y fósforo bajo: hiperparatiroidismo primario. Con PTH suprimida: causa no paratiroidea (PTHrP del carcinoma escamoso, metástasis osteolíticas, mieloma, exceso de vitamina D o granulomas).
- PTH normal o algo alta con calciuria muy baja (FE Ca <1 %): hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que no se opera.
- PTH alta con calcio normal o bajo: hiperparatiroidismo secundario (déficit de vitamina D, enfermedad renal crónica); pedir 25(OH)D.
- Hipocalcemia con PTH baja: hipoparatiroidismo (posquirúrgico) o hipomagnesemia; con PTH alta: déficit de vitamina D o insuficiencia renal.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 79 años, hospitalizada por desnutrición y una neumonía, sin síntomas neuromusculares. Signos de Chvostek y Trousseau negativos. Exámenes: calcio plasmático total 7,8 mg/dL (VN 8,5–10,5), albúmina 2,0 g/dL, fósforo 3,5 mg/dL, magnesio 2,0 mg/dL, creatinina 0,8 mg/dL. **¿Cuál es la interpretación más adecuada de la calcemia?**

A Hipocalcemia verdadera; iniciar gluconato de calcio endovenoso

B Déficit de vitamina D; iniciar colecalciferol en dosis altas

C Hipoparatiroidismo; solicitar PTH e iniciar calcitriol

D Calcemia corregida normal (cerca de 9,4 mg/dL), por hipoalbuminemia; no requiere tratamiento de calcio

E Hipocalcemia por hipomagnesemia

Respuesta D. El calcio total se une en un 40 % a la albúmina. Calcio corregido = calcio medido + 0,8 × (4 – albúmina) = 7,8 + 1,6 = 9,4 mg/dL: normal. Es una pseudohipocalcemia por hipoalbuminemia, asintomática; si hay duda, se mide el calcio iónico. La PTH solo se estudia ante una hipocalcemia verdadera.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 66 años, fumador de 45 paquetes-año, con 3 semanas de constipación, poliuria, baja de peso y somnolencia. Calcio total 13,2 mg/dL con albúmina 4,0 g/dL, fósforo 2,4 mg/dL, creatinina 1,3 mg/dL. PTH intacta 6 pg/mL (VN 15–65). La radiografía de tórax muestra una masa hiliar derecha. **¿Cuál es el mecanismo más probable de la hipercalcemia?**

A Hiperparatiroidismo primario por adenoma paratiroideo

B Intoxicación por vitamina D

C Secreción de péptido relacionado con la PTH (PTHrP) por un carcinoma escamoso pulmonar

D Hiperparatiroidismo terciario

E Hipercalcemia hipocalciúrica familiar

Respuesta C. El primer paso ante una hipercalcemia es medir la PTH. PTH elevada o inapropiadamente normal indica hiperparatiroidismo primario; PTH suprimida indica una causa no paratiroidea, y en un fumador con masa pulmonar lo más probable es la hipercalcemia humoral maligna por PTHrP, típica del carcinoma escamoso. El PTHrP no se detecta en el ensayo de PTH intacta.

▶ VER CLASE 1.03.4.011 **Calciuria** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.1 · Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Calciuria de 24 h: parte del estudio metabólico de la litiasis recurrente (junto a oxalato, citrato, ácido úrico, sodio, creatinina y volumen urinario).
- Hipercalciuria: >300 mg/día en hombres, >250 mg/día en mujeres o >4 mg/kg/día; la causa más frecuente en litiasis cálcica es la hipercalciuria idiopática, con calcemia y PTH normales.
- Con hipercalcemia y PTH alta orienta a hiperparatiroidismo primario (calciuria >400 mg/día es criterio de paratiroidectomía); una calciuria muy baja (FE Ca <1 %) con hipercalcemia sugiere hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que no se opera.
- También aumenta en exceso de vitamina D, sarcoidosis, acidosis tubular renal distal y dieta alta en sodio o proteínas.
- Manejo de la hipercalciuria: abundante agua, dieta baja en sodio con calcio normal (no restringir lácteos) y, si persiste, hidroclorotiazida; citrato de potasio si hay hipocitraturia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 38 años ha tenido 3 episodios de cólico renal en 2 años por cálculos de oxalato de calcio. Su calcemia, PTH y función renal son normales. **¿Qué examen es el más importante para orientar la prevención de nuevos cálculos y cuál es el hallazgo más frecuente?**

A Uricemia: hiperuricemia

B Calciuria de 24 horas: hipercalciuria idiopática

C Cistinuria: cistinuria

D Urocultivo: infección por Proteus

E Cintigrama renal: hidronefrosis

Respuesta B. La litiasis recurrente amerita estudio metabólico en orina de 24 horas (calcio, oxalato, citrato, ácido úrico, sodio, volumen). La alteración más frecuente en la litiasis cálcica es la hipercalciuria idiopática, con calcemia y PTH normales. Se maneja con abundante agua, dieta baja en sodio con calcio normal y, si persiste, tiazidas.

04

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

72 CÓDIGOS

147 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	28
Situaciones clínicas de urgencia	11
Conocimientos generales	13
Exámenes e imagenología	16
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	4

Situaciones clínicas

28 códigos

▶ VER CLASE 1.04.1.001 Adenitis, adenoflegmón

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.4 · Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

QUÉ HAY QUE SABER

- Adenitis cervical aguda: ganglio unilateral doloroso, caliente y eritematoso con fiebre, típico en preescolares; agentes habituales S. aureus y S. pyogenes, a menudo tras impétigo o faringitis.
- Adenoflegmón: adenitis que se abscede; fluctuación central al examen. La ecografía cervical confirma la colección cuando hay duda.
- Adenitis sin fluctuación: antibiótico oral antiestafilocócico (cefadroxilo o flucloxacilina) por 10 días, analgesia y control a las 48–72 h.
- Con fluctuación: drenaje de la colección más antibiótico antiestafilocócico; enviar el pus a Gram y cultivo.
- Seguimiento: control hasta la resolución; biopsia solo si la adenopatía persiste, es dura, indolora o hay síntomas B (descartar linfoma o TBC ganglionar fría que fistuliza).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 3 años presenta aumento de volumen cervical derecho de 4 días, doloroso, con fiebre de 38,5 °C. Al examen hay un ganglio submandibular de 3 cm, eritematoso, caliente y fluctuante al centro. Tuvo un impétigo facial reciente. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Observación y control en 1 mes

B PPD y tratamiento antituberculoso

C Biopsia excisional para descartar linfoma

D Drenaje del adenoflegmón y antibiótico con cobertura antiestafilocócica

E Antiviral oral

Respuesta D. La adenitis cervical aguda unilateral con signos inflamatorios en un preescolar se debe en general a S. aureus o S. pyogenes, a menudo tras impétigo o faringitis. Con fluctuación (adenoflegmón) se requiere drenaje más antibiótico antiestafilocócico (ej. cefadroxilo o flucloxacilina). La biopsia se reserva para adenopatías persistentes, duras, indoloras o con síntomas B.

▶ VER CLASE 1.04.1.003 Ántrax

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 4.6 · Ántrax (Carbunco Cutáneo y Respiratorio)

QUÉ HAY QUE SABER

- Ántrax o carbunco (Bacillus anthracis, bacilo Gram positivo esporulado): exposición ocupacional a ganado, cueros, lana o huesos; la forma cutánea es el 95 % de los casos.
- Sospecha: pápula pruriginosa que pasa a vesícula y luego a escara negra central seca, con corona de vesículas y edema gelatinoso extenso; característicamente indolora y sin pus.
- Diferencial: aracnoidismo cutáneo y tularemia (muy dolorosos), ectima gangrenoso (neutropénicos), celulitis (dolorosa, sin escara). Forma inhalatoria: cuadro gripal que evoluciona a disnea, shock y mediastino ensanchado.
- Inicial: Gram del líquido vesicular (bacilos Gram positivos en caña de bambú), PCR en el ISP y notificación inmediata a la SEREMI; ciprofloxacino 500 mg c/12 h oral (alternativa doxiciclina 100 mg c/12 h). Nunca desbridar la escara.
- Formas sistémicas o inhalatorias: ciprofloxacino + clindamicina + meropenem EV. Seguimiento: derivar a infectología.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 52 años, curtidor de cueros y lanares en una estancia rural, con una lesión en el antebrazo derecho de 5 días, que partió como una "picadura" que no dolía. Presenta una placa ulcerada de 2 cm con escara negruzca seca, rodeada de vesículas serosas y un extenso edema duro de todo el antebrazo. Es indolora y sin exudado purulento. Afebril, en buenas condiciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Aracnoidismo cutáneo necrótico

B Carbunco cutáneo

C Ectima gangrenoso

D Celulitis por Staphylococcus aureus

E Tularemia ulceroglandular

Respuesta B. Exposición ocupacional a cueros y lana + escara negra seca con corona de vesículas y edema extenso, indolora y sin pus: carbunco cutáneo por B. anthracis. El aracnoidismo y la tularemia son muy dolorosos; el ectima gangrenoso ocurre en neutropénicos; la celulitis es dolorosa y sin escara. Conducta: Gram y cultivo/PCR del líquido vesicular, notificación inmediata y ciprofloxacino, sin desbridar.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un trabajador de una fábrica procesadora de cueros importados consulta por una lesión en el dorso de la mano izquierda de 4 días de evolución. Al examen se observa una escara negruzca central de consistencia dura, rodeada por vesículas con líquido claro y un marcado edema indurado en toda la mano, sin dolor a la palpación ni secreción purulenta. **¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?**

A Ciprofloxacino oral

B Cefazolina endovenosa

C Flucloxacilina oral

D Aciclovir tópico

E Corticoides sistémicos a dosis altas

Respuesta A. Escara necrótica negruzca indolora con vesículas satélites y edema masivo en un trabajador expuesto a cueros: carbunco cutáneo. El tratamiento de elección es ciprofloxacino oral (500 mg cada 12 h) o, alternativamente, doxiciclina.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

¿Cuál de las siguientes conductas está formalmente CONTRAINDICADA en el manejo de una lesión cutánea sospechosa de carbunco (ántrax) por Bacillus anthracis? **Seleccione la conducta contraindicada.**

A Toma de frotis de líquido vesicular para tinción de Gram

B Desbridamiento y resección quirúrgica amplia de la escara necrótica

C Notificación obligatoria inmediata a la autoridad sanitaria

D Inicio precoz de tratamiento con quinolonas

E Aislamiento de contacto del paciente con la lesión cubierta

Respuesta B. El desbridamiento, curetaje o escisión de la escara está contraindicado: la manipulación rompe la barrera tisular y favorece el paso de bacterias y toxinas a la sangre, con bacteriemia, shock tóxico y muerte.

▶ VER CLASE 1.04.1.004 Brucelosis

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 4.5 · Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea

QUÉ HAY QUE SABER

- Brucelosis (B. melitensis, cocobacilo Gram negativo intracelular): consumo de leche o queso de cabra sin pasteurizar o contacto ocupacional con ganado, fetos y placentas (veterinarios, matarifes).
- Sospecha: fiebre ondulante vespertina prolongada, sudoración profusa con olor a paja húmeda, astenia intensa, artralgias y hepatoesplenomegalia.
- Complicación focal más frecuente: osteoarticular (sacroileítis, espondilodiscitis); pensar en ella ante lumbago o dolor glúteo en un paciente febril.
- Confirmación: Rosa de Bengala como tamizaje y aglutinación en tubo; hemocultivo o mielocultivo en medio bifásico de Ruiz-Castañeda con incubación prolongada.
- Tratamiento: doxiciclina 100 mg c/12 h + rifampicina 600–900 mg/día por 6 semanas (alternativa: doxiciclina 6 semanas + gentamicina las 2 primeras); la monoterapia o los cursos cortos recaen. Seguimiento: derivar a infectología.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 6

Veterinario expuesto a ganado, con dolor articular. Artrocentesis con PMN 70%. **¿Cuál es el agente o diagnóstico más probable?**

A Brucelosis

B Fiebre Q

C Staphylococcus aureus

D Streptococcus pneumoniae

E Escherichia coli

Respuesta A. El nexo ocupacional (veterinario con ganado) más compromiso articular apunta a brucelosis, cuya complicación focal más frecuente es osteoarticular (sacroileítis, espondilodiscitis, artritis).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 42 años, criador de cabras en la precordillera de Coquimbo, con 5 semanas de fiebre vespertina hasta 38,8 °C, calofríos, astenia y sudoración nocturna profusa. Hace 10 días presenta dolor lumbar bajo que se irradia al glúteo derecho. Hepatomegalia sensible y dolor a la maniobra de Fabere derecha. Consume leche y queso de cabra artesanal. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Ciprofloxacino oral en monoterapia por 14 días

B Doxiciclina 100 mg c/12 h + rifampicina 600–900 mg/día por 6 semanas

C Ceftriaxona 2 g/día EV por 7 días

D Penicilina G sódica EV por 7 días

E Azitromicina 1 g/día oral por 7 días

Respuesta B. Lácteos caprinos no pasteurizados + fiebre ondulante con sudoración + sacroileítis: brucelosis por B. melitensis. Se confirma con Rosa de Bengala y aglutinación o hemocultivo en Ruiz-Castañeda, y se trata con biterapia prolongada (doxiciclina + rifampicina 6 semanas) para evitar recaídas. La monoterapia corta recae; ceftriaxona y azitromicina son de la tifoidea; la penicilina, de la leptospirosis.

▶ VER CLASE 1.04.1.005 Candidiasis oral y esofágica

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.2 · Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

QUÉ HAY QUE SABER

- Candidiasis oral (muguet): placas blanquecinas que se desprenden con el bajalenguas; en adultos sin causa evidente obliga a buscar VIH, diabetes, corticoides inhalados o antibióticos recientes.
- Candidiasis esofágica: muguet más odinofagia o disfagia en inmunosuprimido (VIH con CD4 <200); es enfermedad definitoria de SIDA.
- Oral leve: nistatina tópica (suspensión en enjuagues) o clotrimazol; no sirve para la forma esofágica.
- Esofágica: tratamiento empírico con fluconazol oral por 14–21 días, sin endoscopía previa.
- Si no mejora en pocos días: endoscopía con biopsia para buscar CMV o herpes. Seguimiento: derivar a infectología para estudio y manejo de la inmunosupresión de base (TARV).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 34 años con VIH, CD4 de 90 células/mm³ y sin terapia antirretroviral, consulta por odinofagia y disfagia de 1 semana. Al examen tiene placas blanquecinas en la mucosa oral que se desprenden con un bajalenguas. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Nistatina tópica

B Endoscopía con biopsia antes de cualquier tratamiento

C Aciclovir endovenoso

D Ganciclovir

E Fluconazol oral

Respuesta E. Muguet más odinofagia en un paciente con VIH y CD4 bajo 200 es, con alta probabilidad, candidiasis esofágica. Se trata empíricamente con fluconazol oral por 14 a 21 días; la endoscopía se reserva si no mejora en pocos días, para buscar CMV o herpes. La nistatina tópica solo sirve en la candidiasis oral leve.

▶ VER CLASE 1.04.1.006 Celulitis bacteriana

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.1 · Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Celulitis: infección de dermis profunda y subcutáneo por S. aureus y S. pyogenes; eritema, calor y edema de bordes difusos, de instalación en 24–48 h. Buscar la puerta de entrada (tinea pedis interdigital, úlcera, herida, picadura).
- Erisipela: dermis superficial, S. pyogenes en >90 %; placa rojo brillante de bordes netos y sobreelevados, inicio brusco con fiebre alta y calofríos; el linfedema predispone.
- Leve: marcar el borde con lápiz y cefadroxilo 500 mg c/12 h, cefalexina 500 mg c/6 h o flucloxacilina 500 mg c/8 h por 7–10 días; alergia, clindamicina 300 mg c/8 h; sospecha de SAMR comunitario, cotrimoxazol forte c/12 h. La amoxicilina no cubre bien al estafilococo.
- Hospitalizar y pasar a cefazolina 1 g c/8 h EV o cloxacilina si hay toxicidad sistémica o sepsis, progresión a 48 h pese a tratamiento oral, comorbilidad descompensada (diabetes, cirrosis, inmunosupresión) o celulitis facial.
- Descartar fascitis necrotizante (dolor desproporcionado, bulas, crepitación, shock). Seguimiento: control a las 24–48 h, tratar la puerta de entrada y elevar la extremidad.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años, diabético, con 3 días de eritema caliente y doloroso, de bordes difusos, en la pierna izquierda, que se extiende desde una fisura interdigital. T° 38,8 °C, FC 108 por minuto, PA 125/75 mmHg. Sin crepitación ni dolor desproporcionado; la ecografía no muestra colecciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Cefadroxilo oral y control ambulatorio en 48 horas

B Aciclovir oral

C Desbridamiento quirúrgico de urgencia

D Mupirocina tópica

E Hospitalizar y tratar con cefazolina endovenosa, además de manejar la puerta de entrada

Respuesta E. Celulitis con compromiso sistémico, fiebre y taquicardia, en un diabético requiere hospitalización y antibiótico endovenoso contra estreptococo y estafilococo, como cefazolina; además se trata la puerta de entrada, el intertrigo. El cefadroxilo oral sirve para la celulitis leve sin toxicidad. El desbridamiento se reserva para la fasceítis necrotizante.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 106

Una paciente de 30 años presenta una caída, con erosión de la rodilla derecha. Us- ted la evalúa 3 días después, observándose una zona eritematosa que rodea la herida, de 10 cm de diámetro y bordes parcialmente definidos. ¿Cuál es el tratamiento más ade- cuado?

A Curación con suero fisiológico y cobertura con apósito

B Curaciones con povidona yodada

C Mupirocina tópica

D Amoxicilina oral por 7 días

E Cefadroxilo oral por 7 días

Respuesta E. Una zona eritematosa de 10 cm alrededor de una herida abrasiva infectada con bordes parcialmente definidos corresponde a una celulitis o erisipela no purulenta, que se trata con un antibiótico oral con cobertura para estreptococo y estafilococo, como cefadroxilo por 7 días. La amoxicilina sola no cubre bien a estafilococos productores de penicilinasa, y las curaciones o la mupirocina tópica no bastan para una infección de tejidos blandos extendida.

▶ VER CLASE 1.04.1.007 Cólera

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 2.4 · Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera

QUÉ HAY QUE SABER

- Cólera (V. cholerae O1/O139): agua o mariscos contaminados; la toxina activa la adenilato ciclasa y abre el CFTR, causando diarrea secretora.
- Sospecha: diarrea acuosa profusa en «agua de arroz», sin sangre, sin fiebre ni dolor importante, con vómitos; pérdidas de hasta 1 L/h y shock hipovolémico en horas. Pensarlo en viajeros desde zona endémica.
- Prioridad absoluta: rehidratación. SRO OMS si tolera vía oral; Ringer lactato EV enérgico si hay shock o deshidratación severa.
- Antibiótico en cuadros moderados a severos (solo acorta la diarrea): doxiciclina 300 mg dosis única; niños y embarazadas, azitromicina dosis única. No usar loperamida.
- Enfermedad de notificación obligatoria inmediata. Seguimiento: derivar y hospitalizar para manejo de volumen y estudio con coprocultivo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 35 años regresó hace 2 días de Haití. Presenta diarrea acuosa muy abundante, con aspecto de agua de arroz, sin fiebre ni dolor importante, y vómitos. PA 80/50 mmHg, FC 125 por minuto, mucosas secas y signo del pliegue positivo. **¿Cuál es la medida más importante del tratamiento?**

A Esperar el coprocultivo antes de iniciar el tratamiento

B Loperamida para frenar las pérdidas

C Ciprofloxacino como única medida

D Rehidratación endovenosa enérgica con Ringer lactato

E Vancomicina oral

Respuesta D. Diarrea acuosa profusa tipo agua de arroz después de estar en zona endémica sugiere cólera. Lo que salva la vida es la rehidratación: endovenosa enérgica con Ringer lactato si hay shock y luego sales orales. El antibiótico, como doxiciclina o azitromicina en dosis única, solo acorta la diarrea. Es de notificación inmediata.

▶ VER CLASE 1.04.1.008 Dengue

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 4.3 · Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla

QUÉ HAY QUE SABER

- Dengue (Aedes aegypti, 4 serotipos): en Chile casos importados y transmisión local en Isla de Pascua; la segunda infección por otro serotipo es la de mayor riesgo de dengue grave.
- Sospecha en viajero: fiebre alta súbita, cefalea retroorbitaria, mialgias y artralgias intensas, exantema con «islas blancas»; la fase crítica (días 3–7) coincide con la caída de la fiebre.
- Signos de alarma (basta uno para hospitalizar): dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de fluidos, sangrado de mucosas, letargia o irritabilidad, hepatomegalia >2 cm, hematocrito en ascenso con plaquetas <100.000.

- Sin alarma: manejo ambulatorio con hidratación oral, paracetamol y educación de signos de alarma; AINE y aspirina contraindicados. Con alarma: hospitalizar con cristaloides EV. Confirmar con antígeno NS1 (primeros 5 días) o IgM (después del 5.º día).
- Notificación obligatoria inmediata. Seguimiento: derivar los casos con signos de alarma.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Joven de 26 años con 4 días de fiebre hasta 39,5 °C, dolor retroorbitario intenso que empeora con los movimientos oculares, mialgias y artralgias severas. Regresó hace 5 días del noreste de Brasil. T° 38,8 °C, PA 110/70 mmHg, FC 92 lpm. Exantema eritematoso en tronco que respeta pequeñas zonas redondeadas de piel sana. Sin dolor abdominal ni sangrado. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Confirmar con NS1 o IgM, manejo ambulatorio con hidratación oral y paracetamol, y educar signos de alarma

B Hospitalizar e iniciar cristaloides endovenosos

C Indicar ketoprofeno para las mialgias y control en una semana

D Solicitar gota gruesa e iniciar arteméter-lumefantrina

E Iniciar antiviral específico y aislamiento respiratorio

Respuesta A. Viaje a zona endémica con fiebre, dolor retroorbitario, mialgias y exantema con islas blancas: dengue sin signos de alarma. Se confirma con NS1 o IgM, manejo ambulatorio con hidratación oral y paracetamol, y se educa sobre los signos de alarma. Los AINE están contraindicados; no hay antiviral; sin alarma no se hospitaliza.

▶ VER CLASE 1.04.1.009 Diarrea asociada a antibióticos

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.2 · Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

QUÉ HAY QUE SABER

- Diarrea asociada a antibióticos: C. difficile es la principal causa, sobre todo tras fluoroquinolonas, clindamicina y cefalosporinas, y en pacientes hospitalizados.
- Sospechar ante diarrea acuosa durante o después de un antibiótico u hospitalización, con dolor abdominal, fiebre, leucocitos fecales y a veces sangre.
- Confirmación: toxinas o PCR de toxina de C. difficile en deposiciones (a menudo con GDH); el coprocultivo habitual no lo detecta y la colonoscopía se reserva para casos dudosos o graves.
- Tratamiento: suspender el antibiótico gatillante si es posible, hidratación y vancomicina oral (o fidaxomicina); el metronidazol queda como alternativa. No usar loperamida.
- Prevención y seguimiento: aislamiento de contacto con lavado de manos con agua y jabón (el alcohol no destruye las esporas), uso racional de antibióticos y control clínico por riesgo de recurrencia.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 132

Un paciente es hospitalizado durante 10 días por una neumonía neumocócica adquirida en la comunidad. Algunos días después de ser dado de alta, presenta diarrea líquida abundante, con 5 a 6 evacuaciones al día, asociada a dolor abdominal, malestar general y febrículas hasta 37,3 °C. **¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?**

A Colonoscopía

B Parasitológico ampliado de deposiciones

C Coprocultivo

D PCR para Clostridioides difficile

E Ecografía abdominal

Respuesta D. Diarrea que aparece después de una hospitalización con uso de antibióticos obliga a descartar Clostridioides difficile. El examen de elección es la PCR de toxina en deposiciones, que reemplazó a las pruebas de toxina A y B.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 128

Una paciente está en tratamiento con ciprofloxacino por una infección urinaria. Al séptimo día inicia diarrea acuosa, abundante, asociada a dolor abdominal. Al examen físico se constata dolor a la palpación abdominal, sin irritación peritoneal, con aumento de los ruidos hidroaéreos. Los leucocitos fecales resultan positivos. **¿Cuál es el agente etiológico?**

A Escherichia coli

B Clostridioides (Clostridium) difficile

C Shigella flexneri

D Rotavirus

E Campylobacter jejuni

Respuesta B. Diarrea inflamatoria durante un tratamiento antibiótico obliga a sospechar C. difficile, la principal causa de diarrea asociada a antibióticos (fluoroquinolonas, clindamicina, cefalosporinas). Se confirma con toxinas o PCR en deposiciones y se suspende el antibiótico si es posible. Hoy se trata con vancomicina oral o fidaxomicina; el metronidazol es alternativa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 59

Paciente de 70 años, diabético en tratamiento farmacológico y hospitalizado por neumonía desde hace 5 días, comienza desde ayer con cuadro de deposiciones diarreicas acuosas asociado a desorientación temporoespacial. Al examen físico destaca abdomen doloroso a palpación profunda, con ruidos hidroaéreos aumentados y ausencia de irritación peritoneal. Se solicita coprocultivo que se informa negativo y leucocitos fecales positivos. El tratamiento de elección en este caso es:

A Hidratación por vía oral abundante
B Metronidazol oral
C Ciprofloxacino oral
D Clindamicina ev
E Probióticos orales

Respuesta B. Diarrea por ATB, probablemente por C. difficile. Se trata con MTZ. Eso sí, primero se debería confirmar el diagnóstico con la PCR para Clostridium difficile.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 64

Una mujer de 28 años, puérpera de 2 meses, con 3 semanas de diarreas con presencia de sangre y dolor abdominal difuso leve. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con abdomen blando, sensible a la palpación profunda, sin signos de irritación peritoneal, con meteorismo. El diagnóstico más probable es:

A Diarrea debida a Clostridium difficile
B Colitis ulcerativa
C Enfermedad de Cröhn
D Colitis inespecífica
E Shigellosis

Respuesta A. Seguro recibió antibióticos en el puerperio, por lo que se sospecha la diarrea por C. difficile. Las otras opciones no tienen relación con el antecedente de puerperio.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 126

Paciente con antecedente de diverticulitis hace 10-15 días tratada con ATB oral (ciprofloxacino + metronidazol), consulta SU por diarrea múltiples episodios, con pujo y tenesmo, fiebre? dolor y sangrado: a. Diarrea por clostridium (sg yo era un cuadro clásico de diarrea por CD 2° a uso de ATB) b. Reagudización de diverticulitis por rectitis c. Absceso diverticular no puede ser CU? - el pujo y tenesmo no orientaría a CU? Vi una similar en una reconstrucción y era CU x eso,, era muy vieja para ser CU

A Staphylococcus aureus
B Streptococcus pneumoniae
C Escherichia coli
D Pseudomonas aeruginosa
E Klebsiella pneumoniae

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Staphylococcus aureus). La insulina es el tratamiento de elección en la diabetes tipo 1 y tiene indicaciones precisas en la diabetes tipo 2.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 113

Una paciente de 43 años es diagnosticada de bronquitis, iniciándose tratamiento con amoxicilina oral por 14 días, con buena respuesta. Al décimo día de tratamiento antibiótico evoluciona con dolor abdominal y diarrea, que en oportunidades es sanguinolenta. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Agregar sales de rehidratación oral
B Solicitar parasitológico seriado de deposiciones
C Agregar ciprofloxacino al tratamiento
D Solicitar colonoscopía
E Suspender el tratamiento antibiótico y solicitar toxinas de Clostridium difficile en deposiciones

Respuesta E. Lo más importante es confirmar el diagnóstico de C. difficile. Sin embargo, las toxinas han sido desplazadas por la PCR (aunque tiene más falsos positivos) y en general no es necesario suspender los antibióticos (en este caso sí se debían suspender, porque no estaban indicados, ya que las bronquitis no se tratan con ATB).

▶ VER CLASE 1.04.1.010 **Enfermedades de transmisión sexual** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Infectología 3.4 · Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas
Infectología 3.5 · Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH
Reumatología 9.19 · Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Uretritis gonocócica: secreción purulenta abundante con incubación de 2–7 días; Gram con diplococos Gram negativos intracelulares. No gonocócica (Chlamydia 40–50 %, Mycoplasma, Trichomonas): secreción escasa, «gota matinal», Gram solo con PMN.
- Toda uretritis o cervicitis lleva doble cobertura: ceftriaxona 500 mg IM dosis única + doxiciclina 100 mg c/12 h por 7 días (o azitromicina 1 g dosis única). Ciprofloxacino no: resistencia del gonococo >50 %.
- Úlceras: indolora e indurada = sífilis (penicilina benzatina 2.400.000 UI IM); vesículas en racimo dolorosas = herpes (aciclovir 400 mg c/8 h por 7–10 días); úlcera sucia dolorosa con bubón = chancroide (azitromicina 1 g o ceftriaxona 250 mg IM).

- Condilomas (VPH 6 y 11): podofilotoxina 0,5 %, imiquimod 5 % o crioterapia; en embarazo crioterapia o ácido tricloroacético (podofilina contraindicada). Artritis reactiva post Chlamydia: oligoartritis, uretritis y conjuntivitis con líquido sinovial estéril.
- Toda ITS obliga a buscar las otras (VIH, sífilis, hepatitis B), tratar a las parejas de los últimos 60 días y abstinencia por 7 días. Seguimiento: control de curación y consejería en preservativo.

PREGUNTAS · 13

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 86

Mujer de 26 años, sexualmente activa y alérgica a la penicilina, consulta por disuria y molestias genitales de 4 días, con leucorrea. Al examen hay signos inflamatorios en el cuello uterino, con escasa leucorrea. El cultivo de Thayer Martin resulta positivo, y la prueba de aminas, negativa. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A Ciprofloxacino
B Ceftriaxona
C Azitromicina
D Doxiciclina
E Penicilina benzatina

Respuesta B. Cultivo de Thayer Martin positivo: cervicitis gonocócica. A pesar de la alergia a penicilina, la ceftriaxona sigue siendo el fármaco de elección para el gonococo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 136

Un paciente consulta porque hace 3 días notó aparición de una úlcera en el pene, ubicada en el glande, de 1 cm de diámetro, de aspecto indurado, fondo limpio y sin otros síntomas. Además, se palpa una adenopatía inguinal derecha indolora. Se solicita VDRL y FTA-ABS, resultando ambos negativos. **El diagnóstico más probable es:**

A Sífilis primaria
B Chancroide
C Enfermedad de Behcet
D Infección por virus papiloma humano
E Linfogranuloma venéreo

Respuesta A. Chancro clásico: úlcera indurada, de fondo limpio, con adenopatía indolora. A los 3 días la serología (treponémica y no treponémica) suele ser aún negativa: período de ventana. El diagnóstico es clínico y la serología se repite.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 36

Hombre de 25 años con secreción uretral purulenta y disuria de 4 días de evolución. Tinción de Gram: diplococos gram negativos intracelulares. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A Azitromicina 1 g oral dosis única
B Doxiciclina 100 mg c/12h por 7 días
C Ciprofloxacino 500 mg oral dosis única
D Amoxicilina 3 g oral dosis única
E Ceftriaxona 500 mg IM dosis única

Respuesta E. Gonorrea uretral: ceftriaxona 500 mg IM en dosis única es el tratamiento de elección del gonococo. Ciprofloxacino y amoxicilina tienen alta resistencia. A la ceftriaxona se agrega doxiciclina o azitromicina para cubrir la Chlamydia concomitante.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 100

Un paciente de 24 años mantiene relación sexual casual hace 7 días, con penetración vaginal, sin protección evolucionando con disuria, sin otros síntomas. Al examen físico y genital, no hay alteraciones. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Mycoplasma genitalium
B Ureaplasma urealyticum
C Chlamydia trachomatis
D Trichomona vaginalis
E Escherichia coli

Respuesta C. Uretritis poco sintomática, sin secreción purulenta: uretritis no gonocócica, cuyo agente más frecuente es Chlamydia trachomatis. Mycoplasma, Ureaplasma y Trichomonas pueden darla, pero son menos frecuentes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 86

Una mujer de 26 años, sexualmente activa y alérgica a la penicilina, consulta por disuria y molestias genitales, de 4 días de evolución, asociada a leucorrea. Al examen físico, se observan signos inflamatorios en el cuello uterino, con escasa leucorrea. El cultivo de Thayer Martin es positivo y prueba de aminas, negativa. **El tratamiento de elección es:**

A Ciprofloxacino
B Ceftriaxona
C Azitromicina
D Doxiciclina
E Penicilina benzatina

Respuesta B. Cervicitis gonocócica (Thayer Martin es el medio de cultivo del gonococo). El tratamiento de elección del gonococo es la ceftriaxona, y se agrega cobertura para Chlamydia. La prueba de aminas negativa descarta vaginosis bacteriana.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 37

Hombre de 30 años consulta por úlcera indolora en glande de 5 días de evolución, bordes indurados, fondo limpio. Sin adenopatías inguinales dolorosas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Sífilis primaria (chancro sifilítico)
B Herpes genital
C Chancroide (Haemophilus ducreyi)
D Linfogranuloma venéreo
E Carcinoma espinocelular de pene

Respuesta A. Úlcera genital indolora, de bordes indurados y fondo limpio: chancro sifilítico (sífilis primaria). El herpes es doloroso y vesicular; el chancroide es doloroso y de fondo sucio.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 169

Una paciente de 19 años consulta por disuria dolorosa y lesiones vulvares, de 48 horas de evolución. Refiere relaciones sexuales sin protección. Al examen genital, tiene 3 úlceras de fondo amarillento y halo eritematoso. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Molusco contagioso
B Infección por Chlamydia trachomatis
C Herpes genital
D Chancro sifilítico
E Condiloma acuminado

Respuesta C. Varias úlceras superficiales, dolorosas, sobre halo eritematoso y de inicio agudo: herpes genital. El chancro sifilítico es único e indoloro; la Chlamydia no produce úlceras y el condiloma es una verruga.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 91

¿Cuál es la conducta más adecuada ante un hombre joven, que presenta múltiples condilomas acuminados perianales? **Elige la alternativa correcta.**

A Descartar otras enfermedades de transmisión sexual
B Determinar el genotipo del virus papiloma
C Realizar rectosigmoidoscopía
D Realizar tratamiento con podofilino
E Indicar aciclovir oral

Respuesta A. Ante toda ITS, lo prioritario es descartar las demás (VIH, sífilis, hepatitis B). Los condilomas por VPH de bajo riesgo no tienen mayores complicaciones y su tratamiento local puede esperar; genotipificar no cambia la conducta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2018 · PREGUNTA 44

Hombre de 26 años consulta por dolor e inflamación en rodilla derecha y tobillo izquierdo de 2 semanas de evolución. Como antecedente refiere un cuadro de uretritis con disuria hace 1 mes tras una relación sexual no protegida. Al examen físico destaca artritis de rodilla derecha y placas hiperqueratósicas indoloras de aspecto descamativo en plantas de pies (queratodermia blenorrágica). La artrocentesis muestra 25.000 leucocitos/mm³ con cultivos negativos. ¿Cuál es el patógeno causante de la infección primaria desencadenante más probable?

A Neisseria gonorrhoeae
B Chlamydia trachomatis
C Treponema pallidum
D Trichomonas vaginalis
E Herpes simplex virus tipo 2

Respuesta B. En el síndrome de artritis reactiva tras exposición sexual (artritis periférica asimétrica + antecedente de uretritis + queratodermia blenorrágica con líquido articular estéril), el agente etiológico primario responsable de la infección urogenital desencadenante es Chlamydia trachomatis. No se trata de una artritis séptica gonocócica, ya que el líquido sinovial es aséptico.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 26 años con úlcera en el glande de 10 días de evolución. Úlcera de 1,5 cm, bordes regulares sobreelevados, base limpia e indurada, indolora, con adenopatía inguinal derecha no dolorosa. VDRL reactivo 1:32. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A Penicilina benzatina 2.400.000 UI IM en dosis única

B Penicilina benzatina 2.400.000 UI IM semanal por 3 semanas

C Aciclovir oral por 7 días

D Esperar FTA-ABS antes de tratar

E Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 28 días

Respuesta A. Úlcera única, indurada e indolora con adenopatía indolora y VDRL 1:32: sífilis primaria, es decir precoz. Penicilina benzatina 2.400.000 UI IM en dosis única. Además: serología para VIH y hepatitis B, estudio y tratamiento de los contactos sexuales de los últimos 90 días, y VDRL cuantitativo a los 6 y 12 meses.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 22 años, sexualmente activo, con 4 días de disuria intensa y abundante secreción uretral purulenta amarillenta. El Gram de la secreción muestra abundantes polimorfonucleares con diplococos Gram negativos intracelulares. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Ceftriaxona 500 mg IM en dosis única

B Ceftriaxona 500 mg IM dosis única + doxiciclina 100 mg c/12 h oral por 7 días

C Ciprofloxacino 500 mg oral en dosis única

D Doxiciclina 100 mg c/12 h oral por 7 días

E Penicilina benzatina 2.400.000 UI IM en dosis única

Respuesta B. Diplococos Gram negativos intracelulares confirman la uretritis gonocócica, pero por la coinfección con Chlamydia (hasta 40 %) se trata siempre con doble cobertura: ceftriaxona 500 mg IM + doxiciclina 100 mg c/12 h por 7 días (o azitromicina 1 g). Tratar a los contactos de los últimos 60 días y abstinencia por 7 días.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 61

Un hombre de 34 años consulta por disuria, asociada a secreción uretral purulenta, de un día de evolución. Refiere haber tenido relaciones sexuales sin protección hace una semana. Se realiza tinción de Gram de la secreción uretral, observándose abundantes cocáceas Gram negativas intra y extracelulares. El agente etiológico más probable es:

A Neisseria gonorrhoeae

B Treponema pallidum

C Chlamydia trachomatis

D Mycoplasma genitalium

E Streptococcus pyogenes

Respuesta A. Los cocos Gram negativos intra y extracelulares en la secreción uretral purulenta corresponden a Neisseria gonorrhoeae. Se trata con ceftriaxona 250 mg intramuscular en dosis única y, además, se debe cubrir Chlamydia con azitromicina o doxiciclina. Chlamydia no se visualiza con la tinción de Gram.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 110

Un paciente de 24 años mantiene relaciones sexuales, por vía vaginal, sin protección, evolucionando con disuria, sin otros síntomas. Al examen físico y genital, no hay alteraciones. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A Trichomona vaginalis

B Treponema pallidum

C Ureaplasma urealyticum

D Mycoplasma genitalis

E Chlamydia trachomatis

Respuesta E. Pregunta pésima, puede ser cualquiera de las opciones, menos la B. Sin embargo, la causa más frecuente de uretritis no gonocócica es la Chlamydia trachomatis. Si bien le falta clínica para tener una uretritis (solo tiene disuria, sin secreción uretral), pareciera que es lo que se está preguntando, dadas las alternativas.

▶ VER CLASE 1.04.1.011

Enfermedades eruptivas no complicadas (varicela, herpes zoster...)

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.4 · Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster

QUÉ HAY QUE SABER

- Varicela: exantema pruriginoso centrípeto en «cielo estrellado» (máculas, pápulas, vesículas y costras simultáneas); contagia desde 48 h antes del exantema hasta que todas las lesiones son costras (aislamiento aéreo).
- Niño sano: tratamiento sintomático (antihistamínico, paracetamol); aciclovir oral en mayores de 13 años, segundo caso intradomiciliario o enfermedad crónica. Nunca aspirina (síndrome de Reye).
- Herpes zóster: dolor urente previo y vesículas en un dermatoma unilateral; aciclovir 800 mg 5 veces al día o valaciclovir 1 g c/8 h por 7 días, idealmente antes de 72 h. Zóster oftálmico (signo de Hutchinson) o Ramsay-Hunt: derivación urgente.
- Sarampión: pródromo catarral con conjuntivitis, manchas de Koplik y exantema maculopapular confluente céfalo-caudal; rubéola: exantema rosado tenue de 3 días con adenopatías retroauriculares. Ambos de notificación inmediata.

- Escarlatina (Pastia, Filatov, lengua aframbuesada, piel de lija): amoxicilina 50 mg/kg/día por 10 días. Eritema infeccioso (bofetada, exantema en encaje): sintomático. Seguimiento: control de complicaciones y verificar vacunación PNI.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 118

Hombre de 18 años, sin antecedentes, con cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, tos y coriza, que durante el último día se ha asociado a prurito generalizado. Al examen físico destaca presencia de lesiones papulares y vesículas muy pruriginosas en tronco y extremidades, no asociado a otros hallazgos. **El tratamiento de elección en este caso es:**

A Clorfenamina oral
B Aspirina oral
C Aciclovir oral
D Vacuna contra virus herpes 3
E Inmunoglobulina G no específica

Respuesta C. Varicela en un paciente mayor de 13 años: se indica aciclovir oral, por el mayor riesgo de complicaciones del adolescente y el adulto. La aspirina está contraindicada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 118

Hombre de 18 años, sin antecedentes, con 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, tos y coriza, que durante el último día se asocia a prurito generalizado. Al examen físico destacan lesiones papulares y vesículas muy pruriginosas en el tronco y las extremidades, sin otros hallazgos. **¿Cuál es el tratamiento de elección en este caso?**

A Clorfenamina oral
B Aspirina oral
C Aciclovir oral
D Vacuna contra virus herpes 3
E Inmunoglobulina G no específica

Respuesta C. Pápulas y vesículas pruriginosas tras un pródromo es una varicela. En mayores de 12 años, que tienen más riesgo de complicaciones como la neumonía, se indica aciclovir oral, idealmente en las primeras 24 horas del exantema. La aspirina está contraindicada por el riesgo de síndrome de Reye; la clorfenamina solo alivia el prurito.

▶ VER CLASE 1.04.1.012 Fiebre tifoídea y paratifoídea

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 4.5 · Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea

QUÉ HAY QUE SABER

- Fiebre tifoidea (Salmonella Typhi, reservorio exclusivamente humano, transmisión fecal-oral): fiebre en escalera la primera semana con cefalea y constipación.
- Segunda semana: meseta de 39–40 °C con bradicardia relativa (signo de Faget), roséola tífica, hepatoesplenomegalia y diarrea; hemograma con leucopenia, desviación izquierda y aneosinofilia.
- Confirmación según la semana: hemocultivos en la 1.ª (positivos en 80–90 %), coprocultivo en la 2.ª–3.ª, mielocultivo el más sensible (>95 %, aun con antibiótico previo). El test de Widal no confirma.
- Tratamiento: ceftriaxona 2 g/día EV por 7–14 días o azitromicina 1 g/día oral por 7 días; ciprofloxacino solo si es sensible.
- Complicaciones de la 3.ª semana: perforación ileal y hemorragia digestiva (placas de Peyer). Seguimiento: control clínico, coprocultivos de control y estudio de portación crónica vesicular en manipuladores de alimentos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 57

Un niño de 7 años presenta fiebre persistente desde hace 7 días, mayor en la tarde, hasta 38,9 °C, asociada a cefalea, anorexia y dolor abdominal. Al examen físico tiene temperatura: 38,2 °C, frecuencia cardíaca: 62x' y frecuencia respiratoria: 15x'. Se palpa abdomen sensible de manera difusa, sin signos peritoneales. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 35%, glóbulos blancos: 3.700/mm³ con 70% segmentados, 9% cayados, 16% linfocitos, 5% monocitos, 0% eosinófilos y VHS 65 mm/h. Su proteína C reactiva resulta 6,9 mg/L (valor normal: < 0,5 mg/L). **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Brucella melitensis
B Salmonella typhi
C Escherichia coli enterotoxigénica
D Virus de Epstein-Barr
E Citomegalovirus

Respuesta B. Fiebre de una semana con cefalea y dolor abdominal, frecuencia cardíaca de 62 con 38,2 °C (bradicardia relativa) y un hemograma con leucopenia, desviación izquierda y sin eosinófilos: el clásico "hemograma tífico". Es fiebre tifoidea por Salmonella Typhi.

▶ VER CLASE 1.04.1.013 Hidatidosis

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 4.4 · Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Hidatidosis (Echinococcus granulosus): el perro es hospedero definitivo y el humano se infecta al ingerir huevos de sus heces; quistes en hígado (65–75 %, lóbulo derecho) y pulmón (15–25 %, bases).
- Sospecha: masa quística indolora, a menudo hallazgo; en pulmón, vómica de líquido salado con membranas. La eosinofilia puede faltar en el quiste intacto.
- Estudio: ecografía abdominal de elección (vesículas hijas, signo del camalote); radiografía de tórax para el quiste pulmonar; serología (Arco 5 o ELISA IgG) apoya el diagnóstico.
- Complicación más temida: rotura traumática o espontánea con shock anafiláctico y siembra peritoneal; no puncionar el quiste pulmonar.
- Inicial: albendazol 10–15 mg/kg/día y derivar a cirugía (periquistectomía o PAIR en el hepático; cirugía conservadora en el pulmonar). Prevención: no alimentar perros con vísceras crudas y desparasitarlos.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 72

Un hombre de 40 años presenta un cuadro de dolor abdominal, de 3 meses de evolución, leve, intermitente. Al examen físico presenta leve dolor a la palpación del hipocondrio derecho, por lo que se solicita una ecografía de abdomen, que visualiza una lesión hepática quística, con paredes visibles y gruesas, de 8 cm. En sus exámenes destaca hemograma con hematocrito y plaquetas normales, con 8.000 blancos, 50% de neutrófilos, 40% de linfocitos, 3% de eosinófilos y 7% de monocitos. **¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A IgG para Toxoplasma gondii

B Serología para hidatidosis

C Serología para Triquinella spiralis

D IgG para Fasciola hepática (Distoma)

E Examen parasitológico seriado de deposiciones

Respuesta B. Lesión hepática quística con pared gruesa: quiste hidatídico. La ecografía ya orienta; la serología apoya el diagnóstico. La ausencia de eosinofilia no lo descarta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 70

Un paciente de 34 años presenta un episodio de tos intensa, con salida de abundante líquido salobre, con presencia de membranas blanquecinas y restos hemoptoicos. Su examen físico es normal. **¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar el estudio de este paciente?**

A TAC de tórax y abdomen

B Parasitológico de deposiciones

C Radiografía de tórax

D Ecografía abdominal

E Colonoscopía

Respuesta C. Vómica con líquido salobre y membranas: hidatidosis pulmonar. El primer examen es la radiografía de tórax; luego TAC y ecografía abdominal para buscar quistes hepáticos.

▶ VER CLASE 1.04.1.014 Infección por virus de inmunodeficiencia humana (SIDA)

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Infectología 3.1 · Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)
Infectología 3.2 · Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar VIH ante muguet, zóster recurrente, TBC, ITS, neumonía por Pneumocystis o infecciones más graves de lo esperado; la primoinfección da un síndrome mononucleósico con exantema y úlceras orales, a veces con serología aún negativa (ventana).
- Diagnóstico (Ley 19.779: voluntario, confidencial y con consentimiento): tamizaje con ELISA de 4.ª generación o test rápido; un resultado reactivo es preliminar y se confirma con segunda muestra en el ISP. Nunca informar VIH sin confirmación.
- Etapificación CDC: CD4 ≥500, 200–499 o <200; categoría A asintomático, B sintomático no SIDA (muguet, leucoplasia vellosa, zóster), C enfermedad marcadora. SIDA = CD4 <200 o enfermedad definitoria.
- Confirmado: GES; pedir CD4 y carga viral basales. TARV inmediata a todos (Test and Treat), sin importar CD4: tenofovir + lamivudina + dolutegravir en un comprimido diario.
- Inicial: profilaxis con cotrimoxazol forte diario si CD4 <200. Embarazada: TARV de inmediato, lactancia contraindicada y zidovudina al RN. Seguimiento: derivar a centro de atención VIH; I = I con carga viral <50 copias por más de 6 meses.

PREGUNTAS · 9

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 62

Un paciente de 37 años consulta por fiebre y malestar general de dos días de evolución, asociado a odinofagia. Al examen físico, tiene FC: 96x', PA: 110/70 mmHg, T°: 38,0°C. Se observan úlceras orales, se palpan adenopatías cervicales bilaterales y se observa un exantema maculopapular eritematoso con distribución predominante en el tronco. Su examen cardiopulmonar es normal. Al examen neurológico, presenta algún grado de confusión y se palpa rigidez de nuca esbozada. Presenta serología negativa para VIH y para virus de Epstein Barr y se realiza una punción lumbar, que da salida a líquido cefalorraquídeo con pleocitosis de predominio mononuclear y glucorraquia de 55 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Primoinfección por VIH

B Meningoencefalitis por citomegalovirus

C Meningitis bacteriana aguda

D Neurosífilis

E Mononucleosis infecciosa

Respuesta A. Síndrome retroviral agudo: cuadro mononucleósico con úlceras orales, adenopatías y exantema en el tronco, que puede complicarse con meningitis aséptica (LCR mononuclear, glucosa normal). La serología negativa no lo descarta: el paciente está en el período de ventana.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 56

Una paciente de 33 años, VIH positivo, cursa un embarazo bien controlado, con tratamiento antirretroviral y cargas virales indetectables. El recién nacido nace a las 38 semanas, por parto vaginal, sin complicaciones. **¿Cuál de los siguientes es el tratamiento antirretroviral de elección para el recién nacido?**

A Zidovudina (AZT)

B Lamivudina (3TC)

C Nevirapina (NVP)

D Lopinavir (LPV)

E Abacavir (ABC)

Respuesta A. El recién nacido hijo de madre con VIH recibe profilaxis antirretroviral por algunas semanas tras el nacimiento; el fármaco de elección es la zidovudina. Además, la lactancia materna está contraindicada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 57

Un paciente de 21 años, con antecedente de dermatitis atópica y onicomicosis en manos y pies, es diagnosticado por varicela necrohemorrágica la cual es manejada con aciclovir. **¿Cuál de las siguientes patologías de base es más probable que tenga este paciente?**

A Inmunodeficiencia por déficit de inmunoglobulina A

B Inmunodeficiencia por alteración en la fagocitosis

C Inmunodeficiencia por déficit de inmunoglobulina G

D Inmunodeficiencia por déficit de complemento

E Inmunodeficiencia combinada adquirida

Respuesta E. Una varicela grave en un adulto joven, junto con infecciones fúngicas, sugiere un defecto de la inmunidad celular: hay que sospechar infección por VIH y ofrecer el test.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 60

Un paciente de 36 años presenta desde hace un mes tos irritativa, que se ha vuelto productiva, con expectoración mucosa y últimamente mucopurulenta, asociada a fiebre y malesar general. Al examen está enflaquecido, satura 93% a FiO2 ambiental, tiene FC: 80x', PA: 110/60 mmHg y FR: 21 rpm. A su examen pulmonar, se auscultan crépitos difusos en ambos campos pulmonares, más algunas sibilancias. Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación: FOTO (Radiografía de tórax AP, con patrón alveolointersticial bilateral difuso). **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Streptococcus pneumoniae

B Mycobacterium tuberculosis

C Staphilococcus aureus

D Mycoplasma pneumoniae

E Pneumocystis jiroveci

Respuesta E. Un mes de evolución, paciente enflaquecido, crépitos difusos bilaterales y patrón intersticial bilateral difuso: neumonía por Pneumocystis en un VIH que debuta, aunque el enunciado no lo nombre.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 38

Un paciente de 34 años, consulta por cuadro de 5 semanas de tos irritativa y expectoración que ha ido empeorando, agregándose disnea de medianos esfuerzos. Al examen físico se aprecia enflaquecido, con frecuencia respiratoria de 27 por minuto, frecuencia cardiaca de 90 por minuto, presión arterial de 100/70 mmHg y saturación de 92% con FiO2 ambiental. Examen pulmonar muestra crepitaciones, estertores y algunas sibilancias bilaterales. Se solicita radiografía de tórax. **El diagnóstico más probable es:**

A Fibrosis pulmonar
B Asma bronquial
C Neumonitis viral
D Neumonía por mycoplasma
E Neumonía por Pneumocystis jiroveci

Respuesta E. Cinco semanas de evolución con compromiso bilateral en un paciente enflaquecido: neumonía por P. jiroveci. Con un cuadro más corto y sin baja de peso habría que pensar en Mycoplasma. La fibrosis y el asma son crónicas, con otra radiografía; la neumonitis viral es aguda.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 29 años consulta en APS por astenia y candidiasis orofaríngea (muguet) recurrente. Se realiza un test rápido visual para VIH en el CESFAM, que resulta reactivo. El paciente se angustia y pregunta si ya tiene SIDA y si debe avisar a su familia. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Informar el diagnóstico de VIH e iniciar tenofovir + lamivudina + dolutegravir hoy
B Explicar que el test es preliminar y enviar una segunda muestra venosa al ISP
C Repetir el test rápido en 3 meses por posible período de ventana
D Solicitar CD4 y, si son menores de 200, informar etapa SIDA
E Notificar a la familia para que se realicen el test

Respuesta B. Un test rápido reactivo en APS es solo preliminar. Se contiene al paciente, se explica que el resultado es presuntivo y se envía una segunda muestra venosa al ISP. Confirmado, se activa el GES 18, se piden CD4 y carga viral basales y se inicia de inmediato tenofovir + lamivudina + dolutegravir.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

¿Cuál es el esquema antirretroviral de primera línea preferente para el inicio de tratamiento en pacientes adultos con diagnóstico confirmado de infección por VIH en Chile según la guía ministerial vigente? **Seleccione la alternativa correcta:**

A Zidovudina + Lamivudina + Nevirapina
B Tenofovir disoproxilo + Lamivudina + Dolutegravir
C Abacavir + Emtricitabina + Lopinavir/Ritonavir
D Efavirenz + Zidovudina + Atazanavir
E Tenofovir alafenamida en monoterapia

Respuesta B. El esquema preferente GES es una tableta única diaria con dos inhibidores de transcriptasa reversa nucleósidos (tenofovir + lamivudina) y un inhibidor de integrasa (dolutegravir). Reemplazó a los esquemas con efavirenz (efectos neuropsiquiátricos) y zidovudina (mielotoxicidad y anemia).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 31 años con VIH y abandono de terapia presenta cefalea holocraneana y hemiparesia faciobraquial derecha de 5 días de evolución. Su recuento de CD4 es de 45 células/mm³. La RMN cerebral con contraste muestra tres lesiones nodulares con captación en anillo y edema circundante localizadas en el tálamo y ganglios basales izquierdos. **¿Cuál es la conducta médica inicial más adecuada?**

A Indicar biopsia estereotáxica urgente de la lesión talámica
B Iniciar radioterapia holocraneana por sospecha de linfoma primario del SNC
C Iniciar tratamiento empírico para Toxoplasmosis con Sulfadiazina + Pirimetamina y evaluar respuesta en 10-14 días
D Administrar anfotericina B liposomal en monoterapia EV
E Indicar tratamiento antituberculoso con 4 fármacos por 12 meses

Respuesta C. CD4 < 100 con múltiples lesiones en anillo en ganglios basales: toxoplasmosis cerebral. Se inicia tratamiento empírico y se repite la imagen a los 10–14 días; la biopsia se reserva para la falta de respuesta (sospecha de linfoma primario del SNC).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 99

Emb de 32 semanas con Vih (+) sin tto, cual es la mejor conducta para prevenir transmision vertical:

A Iniciar TARV
B interrumpir embarazo
C TARV intraparto
D Interrupción del embarazo
E Maduración pulmonar y observación

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Iniciar TARV (opción A).

▶ VER CLASE 1.04.1.015 Infecciones asociadas a catéteres vasculares

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 2.3 · IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Bacteriemia asociada a catéter venoso central: fiebre y calofríos en portador de CVC sin otro foco; el sitio de inserción puede verse limpio. Agentes: S. epidermidis, S. aureus, bacilos gramnegativos y Candida.
- Precoz (<10 días) por vía extraluminal desde la piel; tardía (>10 días) por vía intraluminal desde conectores e infusiones.
- Confirmación: hemocultivos pareados (periférico y de cada lumen); sugiere catéter el mismo germen con positividad del CVC >2 h antes que el periférico, o recuento CVC/periférico ≥3:1.
- Inicial: vancomicina EV; agregar cobertura de gramnegativos (cefepime, piperacilina-tazobactam o amikacina) si hay sepsis o neutropenia.
- Retiro obligatorio del CVC si hay shock, túnel o sitio con pus, complicaciones metastásicas, S. aureus, Candida, Pseudomonas, multirresistentes o bacteriemia persistente a las 48–72 h. S. aureus exige ecocardiograma; Candida, fondo de ojo. Seguimiento: derivar.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 64 años en UCI por pancreatitis aguda grave, con CVC subclavio derecho desde hace 12 días. Presenta bruscamente fiebre de 39 °C con calofríos y taquicardia. Sitio de inserción limpio, sin eritema ni secreción. Hemocultivos pareados: a las 14 horas crece Staphylococcus aureus meticilino-resistente en ambos frascos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener el CVC, iniciar vancomicina y repetir hemocultivos en 72 horas

B Recambiar el CVC sobre guía en el mismo sitio e iniciar cefazolina

C Retirar el CVC, iniciar vancomicina EV y solicitar ecocardiograma

D Sellado del catéter con vancomicina sin antibiótico sistémico

E Retirar el CVC y observar sin antibióticos, ya que el foco fue removido

Respuesta C. Bacteriemia por CVC por S. aureus: retiro obligatorio del catéter aunque el sitio se vea limpio, vancomicina EV ajustada a niveles de valle (es SAMR) y ecocardiograma transtorácico o transesofágico para descartar endocarditis.

▶ VER CLASE 1.04.1.016 Influenza

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.6 · Virus Respiratorios: Influenza y COVID-19 (Adulto y Niño)

QUÉ HAY QUE SABER

- Influenza: inicio brusco con fiebre alta, mialgias, cefalea, odinofagia y tos seca, en brotes invernales; en adultos mayores puede presentarse solo con decaimiento o confusión.
- Confirmación: panel viral por inmunofluorescencia o PCR de hisopado nasofaríngeo, útil en hospitalizados, grupos de riesgo y vigilancia; en brote el diagnóstico es clínico.
- Tratamiento sintomático (paracetamol, hidratación, reposo); no usar aspirina en niños. Oseltamivir 75 mg c/12 h por 5 días, idealmente en las primeras 48 h, en grupos de riesgo (≥65 años, embarazadas, menores de 2 años, enfermos crónicos, inmunosuprimidos) y en todo caso grave u hospitalizado.
- Signos de gravedad: disnea, hipoxemia, compromiso de conciencia, descompensación de enfermedad de base o neumonía bacteriana secundaria (neumococo, S. aureus); hospitalizar con aislamiento por gotitas.
- Prevención: vacuna anual en campaña PNI para grupos de riesgo y personal de salud. Seguimiento: control a las 48–72 h en grupos de riesgo.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 141

En contexto de un brote de influenza, durante el invierno, un paciente de 22 años presenta un cuadro de rinorrea, congestión nasal, fiebre, mialgias generalizadas y tos seca. Al examen físico presenta temperatura de 39 °C, con examen pulmonar normal. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Oseltamivir

B Zanamivir

C Aciclovir

D Valaciclovir

E Paracetamol

Respuesta E. En un adulto joven sin factores de riesgo ni signos de gravedad, la guía MINSAL indica tratamiento sintomático (paracetamol, reposo e hidratación). El oseltamivir se reserva para grupos de riesgo (embarazadas, adultos mayores, comorbilidades, inmunosupresión) o influenza grave. Aciclovir y valaciclovir actúan sobre herpesvirus, no sobre influenza.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 156

Paciente de 66 años, hipertenso en tratamiento, consulta por cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, tos y coriza, síntomas que se han hecho más intensos en las últimas horas agregándose cefalea y mialgias intensas. Su examen físico muestra temperatura de 38,5ºC, examen pulmonar sin alteraciones. El fármaco de elección para el manejo en este caso es:

A Acetaminofeno
B Oseltamivir
C Claritromicina
D Zanamivir
E Ibuprofeno

Respuesta A. Es una influenza (adulto mayor). Mayor de 60 años es indicación de oseltamivir. Sin embargo el tratamiento de elección para la influenza es el tratamiento sintomático, además que lleva 3 días, por lo que el oseltamivir es menos efectivo. Ambas son respuestas correctas. Es una pregunta muy discutible, pero si la pregunta es cuál es el tratamiento de la influenza, la respuesta es: paracetamol. No les puedo prometer que esta haya sido la respuesta. Lean las páginas 6 y 7 del siguiente link:...

▶ VER CLASE 1.04.1.017 Leptospirosis

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 4.5 · Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea

QUÉ HAY QUE SABER

- Leptospirosis (Leptospira, en túbulos renales de ratas): contacto con agua estancada, barro o inundaciones contaminados con orina de roedor; entra por piel erosionada o mucosas (agricultores, alcantarillado, arrozales, bañistas).
- Forma anictérica (90 %): fiebre bifásica, cefalea, mialgias intensas de pantorrillas y sufusión conjuntival.
- Síndrome de Weil (10 %): ictericia, insuficiencia renal (a menudo con hipokalemia) y hemorragias; la hemorragia pulmonar es letal. Diferencial: hepatitis o colangitis, que no dan sufusión ni mialgias de pantorrillas.
- Confirmación: serología por microaglutinación (MAT). Leve: doxiciclina oral ambulatoria. Grave (Weil): penicilina G sódica EV o ceftriaxona EV.
- Seguimiento: derivar y hospitalizar las formas ictéricas o con falla renal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años, trabajador de arrozales con abundantes roedores, inicia hace 6 días fiebre de 39 °C, cefalea, mialgias intensas en las pantorrillas y sufusión conjuntival. Hoy presenta ictericia y oliguria. Creatinina 3,2 mg/dL, bilirrubina total 8 mg/dL, plaquetas 60.000/mm³ y transaminasas levemente elevadas. **¿Cuál es el tratamiento antibiótico más adecuado?**

A Doxiciclina más rifampicina por 6 semanas
B Albendazol
C Penicilina G sódica o ceftriaxona endovenosa
D Aciclovir endovenoso
E Solo soporte, porque es una hepatitis viral

Respuesta C. Fiebre, mialgias de pantorrillas y sufusión conjuntival tras exposición a agua contaminada con orina de roedores sugiere leptospirosis; ictericia con falla renal es el síndrome de Weil. La forma grave se trata con penicilina G sódica o ceftriaxona endovenosa; la leve, con doxiciclina oral. La hepatitis viral no da sufusión conjuntival ni falla renal.

▶ VER CLASE 1.04.1.018 Malaria

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 4.3 · Enfermedades Transmitidas por Mosquitos: Dengue, Malaria y Fiebre Amarilla

QUÉ HAY QUE SABER

- Malaria (Plasmodium, transmitida por Anopheles): en Chile no hay transmisión autóctona; todos los casos son importados. Pensarla en todo viajero febril desde zona endémica.
- Sospecha: accesos de calofrío, fiebre de 40 °C y sudoración que se repiten, con anemia hemolítica, ictericia y trombocitopenia; la anemia la diferencia del dengue (en este el hematocrito sube).
- P. falciparum es el más letal (malaria cerebral); P. vivax y P. ovale dejan hipnozoítos hepáticos que causan recidivas meses después.
- Diagnóstico de certeza: frotis y gota gruesa con Giemsa, idealmente en el pico febril (trofozoítos en anillo, cuantifica parasitemia). Tratamiento: terapia combinada con artemisinina (arteméter-lumefantrina); vivax u ovale: cloroquina + primaquina 14 días, verificando antes déficit de G6PD.
- Notificación obligatoria inmediata. Seguimiento: derivar a infectología y hospitalizar si es falciparum o hay signos de gravedad.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 147

Una paciente realiza un viaje a la selva amazónica y, al cuarto día luego de su regreso, presenta fiebre alta hasta 39,3°C, asociada a cefalea intensa y persistente, con marcado malestar general y mialgias. Se realiza un hemograma, que muestra hematocrito: 24%, hemoglobina: 8 g/dl, glóbulos blancos: 16.000 por mm3, con fórmula diferencial normal, plaquetas: 93.000 por mm3 y VHS: 35 mmHg. **El agente etiológico más probable es:**

A Viruz zika
B Virus dengue
C Plasmodium falciparum
D Salmonella typhi
E Virus de fiebre amarilla

Respuesta C. La clínica es compatible con dengue, pero la anemia marcada (Hb 8 g/dl, Hto 24%) apunta a hemólisis: malaria. En el dengue que se complica el hematocrito sube, no baja. A la fiebre amarilla le falta la ictericia.

▶ VER CLASE 1.04.1.019

Micosis invasora (aspergillosis, candidiasis, mucormicosis)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.5 · Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco

QUÉ HAY QUE SABER

- Micosis invasora: en neutropénicos, trasplantados, quimioterapia, diabéticos descompensados o pacientes críticos; se sospecha ante fiebre persistente (4.º–7.º día) pese a antibióticos de amplio espectro con cultivos negativos.
- Aspergilosis pulmonar invasora: tos, hemoptisis y fiebre; la TAC de tórax de alta resolución muestra nódulo o masa con signo del halo.
- Candidiasis invasora: candidemia en portadores de CVC, nutrición parenteral o cirugía abdominal; retirar el catéter y fondo de ojo para descartar endoftalmitis.
- Mucormicosis rinocerebral: diabético (sobre todo con cetoacidosis) con sinusitis, edema facial y necrosis negra del paladar o ala nasal; requiere desbridamiento quirúrgico urgente y anfotericina B.
- Inicial: antifúngico EV empírico (voriconazol para Aspergillus; equinocandina como caspofungina o fluconazol para Candida; anfotericina B liposomal) y no seguir rotando antibióticos. Seguimiento: derivar.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 73

Paciente con diagnóstico de una leucemia mieloide aguda, en su cuarto ciclo de quimioterapia, se encuentra hospitalizado por fiebre sin foco, asociado a neutropenia (neutropenia febril), por lo que está en tratamiento con ceftazidima, amikacina y vancomicina, sin mayor respuesta. En sus exámenes de laboratorio presenta neutrófilos 100 por mm3 y en la radiografía de tórax se observa una imagen apical derecha radiopaca, de 3 cm de diámetro, espiculada y con bordes difusos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Tuberculosis
B Neumonía intrahospitalaria
C Aspergilosis invasiva
D Nocardosis
E Neumonía por Pneumocystis jiroveci

Respuesta C. La aspergilosis invasiva es una complicación clásica de la neutropenia prolongada y profunda. Por ser un hongo, no responde a los antibióticos. Se estudia con TC de tórax (nódulo con signo del halo) y galactomanano, y se trata con voriconazol.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 29

Un hombre de 29 años, presenta un cuadro de tos seca, de 5 semanas de evolución, a lo que se ha agregado disnea y malestar general. Al examen físico destaca FC: 100x', PA: 110/70 mmHg, temperatura: 37,5 grados Celsius y FR: 30x'. El examen cardiopulmonar, así como la radiografía de tórax son normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Infección por adenovirus
B Infección por virus influenza
C Infección por Bordetella pertusis
D Infección por Pneumocystis jiroveci
E Infección por Mycobacterium tuberculosis

Respuesta D. Tos seca y disnea de 5 semanas con taquipnea en un adulto joven: evolución subaguda que descarta adenovirus e influenza. La radiografía normal no descarta Pneumocystis en un paciente muy inmunosuprimido; tampoco hay clínica de tuberculosis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 124

Un paciente de 41 años, diabético tipo 1, consulta por fiebre, asociado a rinorrea purulenta y enrojecimiento facial. Al examen físico, se observa eritema de la mejilla izquierda y de la punta de la nariz, con una zona necrótica en el ala nasal. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Stafilococcus aureus
B Candida albicans
C Streptococcus pyogenes
D Mucor
E Pseudomona aureginosa

Respuesta D. Diabético con sinusitis y necrosis del ala nasal: mucormicosis rinocerebral, una infección oportunista por hongos del huésped inmunocomprometido que no depende del VIH.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 132

Un paciente, con antecedente de leucemia mieloide crónica, en quimioterapia hace 2 semanas, presenta un cuadro de tos, con expectoración purulenta, con estrías de sangre, asociada a fiebre y malestar general. Se solicitan exámenes, entre los que destaca VHS: 90 mm/h, PCR: 22 mg/L. Se realiza TAC de tórax, que visualiza una tumoración densa, con un halo radiolúcido. **El agente etiológico más probable es:**

A Pseudomona aureginosa
B Aspergillus
C Staphilococcus aureus
D Candida albicans
E Mycobacterium tuberculosis

Respuesta B. Paciente en quimioterapia con tos hemoptoica, fiebre y una masa densa rodeada de un halo en la TAC: aspergilosis pulmonar. Se ve en inmunosuprimidos y en pacientes con lesiones bronquiales previas (bronquiectasias, cavernas tuberculosas).

▶ VER CLASE 1.04.1.020 **Neutropenia febril** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Hematología 8.21 · Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica
Infectología 5.5 · Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco

QUÉ HAY QUE SABER

- Definición: fiebre ≥38,3 °C en una toma o ≥38 °C por más de 1 hora, con RAN <500/mm³ (o <1.000 con caída prevista). RAN = leucocitos × (% segmentados + % baciliformes)/100; nadir 7–14 días post quimioterapia.
- Sin neutrófilos no hay pus ni infiltrado: la fiebre puede ser el único signo. Examinar boca, catéter y zona perianal; tacto rectal y termómetro rectal prohibidos.
- Emergencia: 2 sets de hemocultivos (periférico y de cada lumen del CVC) y antibiótico EV en menos de 60 minutos, sin esperar exámenes ni imágenes.
- Alto riesgo (MASCC <21): hospitalizar en aislamiento con cefepime 2 g c/8 h o piperacilina-tazobactam 4,5 g c/6 h EV (meropenem si shock o BLEE); la ceftriaxona no cubre Pseudomonas. Vancomicina solo si hay inestabilidad, infección del catéter, mucositis grave o SAMR. Bajo riesgo (MASCC ≥21): ciprofloxacino + amoxicilina-clavulánico oral con control en 24 h.
- Fiebre persistente al 4.º–7.º día: TAC de tórax y antifúngico empírico (voriconazol o caspofungina). Seguimiento: derivar a hematología u oncología.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 54 años en quimioterapia por linfoma no Hodgkin, último ciclo hace 9 días. Consulta por calofríos. T° 38,6 °C axilar, FC 110 lpm, PA 100/65 mmHg. Sin foco respiratorio, urinario ni abdominal; sitio del catéter venoso central sano. Leucocitos 800/mm³ (15 % baciliformes, 20 % segmentados), plaquetas 65.000/mm³. **Tras tomar 2 hemocultivos, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Hospitalizar en aislamiento y cefepime 2 g c/8 h EV dentro de la primera hora
B Cefepime más vancomicina EV por el catéter venoso central
C Ceftriaxona 2 g EV y control en 24 horas
D Esperar el resultado de los hemocultivos y buscar el foco
E Ciprofloxacino más amoxicilina-clavulánico oral ambulatorio

Respuesta A. RAN = 800 × 35 % = 280/mm³ con fiebre ≥ 38,3 °C: neutropenia febril. Es de alto riesgo y requiere hospitalización en aislamiento y monoterapia antipseudomónica EV (cefepime) en menos de 60 minutos. No hay shock ni infección del catéter, así que la vancomicina de entrada no está indicada.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 53 años con cáncer de mama en quimioterapia con adriamicina y ciclofosfamida (último ciclo hace 10 días). Consulta por fiebre de 38,6 °C y calofríos de 3 horas. Niega tos, disuria o dolor abdominal. PA 115/70 mmHg, FC 102 lpm, T° 37,8 °C. Catéter venoso central implantable sin signos inflamatorios; boca con eritema leve sin úlceras. Hb 9,4 g/dL, leucocitos 800/µL (segmentados 10%, baciliformes 2%), plaquetas 85.000/µL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Esperar la radiografía de tórax y el urocultivo para decidir el antibiótico

B Tacto rectal para descartar absceso perianal y luego decidir

C Dos sets de hemocultivos (periféricos y por el catéter) y cefepime 2 g EV en menos de 60 minutos

D Ceftazidima más amikacina y vancomicina EV

E Paracetamol y control en 24 horas, ya que está afebril al examen

Respuesta C. RAN = 800 × 12% = 96/µL: neutropenia profunda con fiebre en el nadir. Se toman dos sets de hemocultivos (periféricos y por cada lumen del CVC) y se inicia monoterapia antipseudomónica (cefepime 2 g o piperacilina/tazobactam 4,5 g EV) en menos de 60 minutos, hospitalizando en aislamiento protector. El tacto rectal está contraindicado y no se esperan imágenes.

▶ VER CLASE 1.04.1.021 Osteomielitis

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.2 · Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos

QUÉ HAY QUE SABER

- Osteomielitis: infección ósea hematógena (niños, metáfisis de huesos largos; adultos, columna), por contigüidad (pie diabético, úlceras por presión) o postraumática y posquirúrgica. S. aureus es el agente principal.
- Sospecha: dolor óseo localizado, fiebre, impotencia funcional o cojera en el niño; en el pie diabético, úlcera que llega a hueso (sonda que toca hueso) o que no cicatriza. VHS y PCR elevadas.
- La radiografía es normal las primeras 2 semanas; la RM es el examen de elección (también en espondilodiscitis y mal de Pott). Hemocultivos y cultivo de hueso por biopsia o cirugía antes del antibiótico si el paciente está estable.
- Inicial: hospitalizar, hemocultivos y antibiótico EV antiestafilocócico (cloxacilina o cefazolina; vancomicina si se sospecha SAMR o hay antibiograma resistente).
- Seguimiento: derivar a traumatología o cirugía para drenaje o desbridamiento; tratamiento prolongado (habitualmente 4–6 semanas) por especialista.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 161

Un paciente de 60 años, diabético, consulta por dolor lumbar intenso, de 5 días de evolución, asociado a malestar general y fiebre hasta 38,9°C. Al examinarlo, presenta marcado dolor al presionar la zona vertebral lumbar, con una contractura de la musculatura paravertebral. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A Espondilitis anquilosante

B Aplastamiento vertebral

C Lumbago mecánico

D Lumbociática

E Discitis lumbar

Respuesta E. Dolor lumbar intenso con fiebre, malestar general y dolor a la presión de la columna en un diabético: discitis lumbar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 171

Un niño de 7 años es hospitalizado para manejo quirúrgico de una osteomielitis. El cultivo informa desarrollo de Staphylococcus aureus, cuyo antibiograma muestra resistencia a oxacilina y a cefalosporinas, con sensibilidad a vancomicina. **¿Cuál de los siguientes antibióticos es de elección para el manejo inicial?**

A Flucloxacilina

B Cefazolina

C Vancomicina

D Tetraciclina

E Cotrimoxazol

Respuesta C. El antibiograma corresponde a S. aureus resistente a meticilina (SARM), que resiste a todos los betalactámicos antiestafilocócicos, incluidas flucloxacilina y cefazolina. En una osteomielitis que requiere hospitalización y cirugía, el tratamiento endovenoso de elección es vancomicina. Las tetraciclinas se evitan en menores de 8 años.

▶ VER CLASE 1.04.1.022 Parasitosis intestinales

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.2 · Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

QUÉ HAY QUE SABER

- Giardiasis: la más frecuente en preescolares de jardín infantil o zonas rurales, con varios familiares afectados; diarrea crónica esteatorreica y maloliente, flatulencia, distensión y baja de peso, puede simular celiaquía.
- Diagnóstico: parasitológico seriado de deposiciones (3 muestras en días distintos, con fijador), ya que la eliminación de quistes es intermitente. Test de Graham ante prurito anal (Enterobius).

- Giardia: tinidazol o metronidazol (alternativa nitazoxanida). Trichuris trichiura (gusanos filiformes en ciego y colon ascendente): mebendazol o albendazol.
- Oxiuros: mebendazol o albendazol con segunda dosis a las 2 semanas y tratamiento de todo el grupo familiar; Ascaris: mebendazol o albendazol.
- Prevención y seguimiento: lavado de manos, agua potable y cocción de alimentos; control parasitológico post tratamiento si persisten los síntomas.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 101

Paciente de 45 años con diarrea crónica de 6 meses. Se realiza una colonoscopía que muestra parásitos filiformes adheridos a la mucosa del colon ascendente. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Giardia lamblia
B Entamoeba histolytica
C Trichuris trichiura
D Ascaris lumbricoides
E Cryptosporidium

Respuesta C. Trichuris trichiura (tricocéfalo) es un nematodo en forma de látigo que se adhiere a la mucosa del ciego y colon ascendente, visible en colonoscopía; causa diarrea crónica y, en infecciones masivas, disentería y prolapso rectal. Giardia vive en el duodeno, Ascaris en el intestino delgado, y los protozoos son microscópicos. Se trata con albendazol o mebendazol.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 25

IMAGEN: Parásito intestinal (foto taenia SAGINATA) tratamiento:

A Mebendazol
B Albendazol
C Praziquantel
D Ivermectina
E Derrame pleural

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Praziquantel (opción C).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 23

Una paciente de 28 años consulta ya que lleva varios días eliminando restos de un parásito en sus deposiciones. Se solicita examen parasitológico de deposiciones, que muestra presencia de huevos operculados. ¿Cuál es el antecedente que debe preguntarse dirigidamente para establecer el diagnóstico?

A Consumo de mariscos crudos
B Consumo de sushi de salmón
C Consumo de carne de vaca cruda
D Viaje al caribe
E Contacto con roedores

Respuesta B. Teniasis: La presencia de restos del parásito sugiere una infestación por una tenia. De las tenias, solo el Difilobotrium latum tiene huevos operculados y se transmite por el consumo de pescado crudo. El consumo de carne de vaca cruda puede producir una infestación por Taenia saginata, mientras que la carne de cerdo cruda puede transmitir la Taenia solium. Ambas tienen huevos no operculados.

▶ VER CLASE 1.04.1.023 Sífilis secundaria, terciaria y congénita

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.4 · Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas

QUÉ HAY QUE SABER

- Sífilis secundaria: exantema maculopapular palmoplantar cobrizo (roséola), condilomas planos, placas mucosas y poliadenopatías, semanas después de un chancro indoloro autolimitado.
- Latente: asintomática con serología reactiva, precoz <1 año y tardía >1 año. Terciaria: gomas, aortitis y neurosífilis.
- Sífilis congénita: hepatoesplenomegalia, rinitis serosanguinolenta, pénfigo palmoplantar; se previene con VDRL prenatal y tratamiento oportuno de la madre.
- Confirmación: VDRL o RPR cuantitativo (actividad y seguimiento) más prueba treponémica (FTA-ABS, MHA-TP), que confirma y queda positiva de por vida.
- Inicial: penicilina benzatina 2.400.000 UI IM dosis única en secundaria y latente precoz; semanal por 3 semanas en tardía o de duración desconocida; embarazada alérgica, desensibilizar. Derivar neurosífilis (penicilina sódica EV), terciaria y congénita (penicilina sódica EV por 10 días).

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 62

Un paciente es diagnosticado de infección por VIH, hace 3 meses. Está en etapa A3 e inició tratamiento con triterapia antirretroviral al momento del diagnóstico. Consulta ahora por aparición de placas pruriginosas en el tronco, más algunas lesiones similares en las palmas y plantas. Además tiene una lesión parecida en la cara interna de la mejilla derecha. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Pitiriasis rosada
B Pitiriasis versicolor
C Síndrome pie mano boca
D Sífilis secundaria
E Reacción adversa a la triterapia antirretroviral

Respuesta D. Exantema en tronco con compromiso palmoplantar y de mucosas: sífilis secundaria. Una ITS es el principal factor de riesgo para tener otra.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 130

Una paciente de 25 años, con antecedente de sífilis tratada hace un año, cursando un embarazo de 8 semanas, se realiza un VDRL, que resulta positivo en dilución 1/16. **La conducta más adecuada es:**

A Solicitar FTA-ABS
B Controlar con VDRL seriado
C Solicitar RPR
D Administrar ceftriaxona
E Administrar penicilina benzatina

Respuesta E. En quien ya tuvo sífilis, la treponémica seguirá positiva de por vida: lo que indica actividad o reinfección es el VDRL reactivo. Además, todo VDRL reactivo en el embarazo se trata de inmediato con penicilina benzatina.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 26 años con embarazo de 14 semanas presenta VDRL de tamizaje reactivo 1:16, confirmado con FTA-ABS reactivo. Refiere alergia confirmada a la penicilina (shock anafiláctico previo). **¿Cuál es la conducta indicada para prevenir la sífilis congénita?**

A Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 14 días
B Hospitalizar para desensibilización a la penicilina y luego administrar penicilina benzatina
C Eritromicina oral 500 mg cada 6 horas por 14 días
D Diferir todo tratamiento hasta después del parto
E Ceftriaxona 1 g diario intramuscular por 10 días

Respuesta B. La penicilina es el único antibiótico con eficacia demostrada para tratar a la madre y al feto y prevenir la sífilis congénita. La doxiciclina está contraindicada en el embarazo y los macrólidos no cruzan adecuadamente la placenta: se desensibiliza y se trata con penicilina benzatina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 27

Una mujer embarazada de 8 semanas se toma un VDRL, que resulta positivo en dilución 1/64. Tiene antecedente de alergia a la amoxicilina. El tratamiento de elección es:

A Penicilina
B Clindamicina
C Ceftriaxona
D Eritromicina
E Doxiciclina

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Eritromicina (opción D).

▶ VER CLASE 1.04.1.024 Síndrome febril prolongado

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.5 · Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome febril prolongado: fiebre >38,3 °C por más de 3 semanas sin diagnóstico tras un estudio inicial adecuado.
- Causas: infecciones (clásicamente las más frecuentes: TBC, abscesos, endocarditis), neoplasias (linfomas), enfermedades inflamatorias no infecciosas (arteritis de células gigantes, Still) y misceláneas (fármacos, fiebre facticia).
- Estudio inicial: hemograma, VHS, PCR, perfil bioquímico y hepático, orina completa, hemocultivos, urocultivo, radiografía de tórax y VIH.
- Orientar según la anamnesis epidemiológica (lácteos de cabra: brucelosis; viajes; contacto TBC) y el examen (soplo nuevo, adenopatías, esplenomegalia).
- Inicial: no dar antibióticos empíricos a ciegas en el paciente estable para no negativizar cultivos. Seguimiento: derivar a medicina interna o infectología para estudio dirigido (TAC, ecocardiograma, biopsias).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 50 años presenta fiebre sobre 38,3 °C de 4 semanas de evolución. Tras una semana de estudio hospitalizada (hemograma, perfil bioquímico, examen de orina, hemocultivos, urocultivo, radiografía de tórax y VIH) no se ha encontrado la causa. **¿Cuál es el grupo de causas clásicamente más frecuente de este síndrome en adultos?**

A Infecciones (como tuberculosis, endocarditis y abscesos)

B Fiebre facticia

C Fármacos, exclusivamente

D Enfermedades genéticas

E Simulación

Respuesta A. Fiebre sobre 38,3 °C por más de 3 semanas sin diagnóstico tras un estudio inicial adecuado define el síndrome febril prolongado. Sus causas se agrupan en infecciones (clásicamente las más frecuentes: tuberculosis, abscesos, endocarditis), neoplasias (linfomas), enfermedades inflamatorias no infecciosas (arteritis de células gigantes, Still) y misceláneas.

▶ VER CLASE 1.04.1.025 Síndrome mononucleósico

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Infectología 5.2 · Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH
Otorrino 14.13 · Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

QUÉ HAY QUE SABER

- Mononucleosis por VEB: fiebre prolongada, faringoamigdalitis exudativa, adenopatías cervicales posteriores, esplenomegalia (50–60 %) y hepatomegalia con alza leve de transaminasas.
- Hemograma con linfocitosis y >10 % de linfocitos atípicos; confirmar con anticuerpos heterófilos (Paul-Bunnell o Monotest) o IgM anti-VCA (IgM VCA positiva con IgG negativa = infección aguda).
- La amoxicilina produce exantema maculopapular en casi todos (inmunocomplejos): suspender sin rotular alergia a penicilina.
- Tratamiento de soporte: paracetamol, hidratación y reposo relativo; evitar deportes de contacto por 3–4 semanas por riesgo de rotura esplénica.
- Heterófilos negativos: CMV (fiebre con faringitis mínima), toxoplasmosis (adenopatía indolora) o primoinfección VIH (úlceras orales y exantema; pedir carga viral). Seguimiento: control hasta resolver la esplenomegalia.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 164

Paciente de 17 años presenta un cuadro de fiebre, malestar general y odinofagia, de 7 días de evolución. Al examen, presenta lesiones blanquecinas en las amígdalas y congestión de la orofaringe, adenopatías cervicales y se palpa el bazo moderadamente aumentado de tamaño. **¿Cuál es el agente causal más probable?**

A Adenovirus

B Virus influenza

C Virus de Ebstein Barr

D Citomegalovirus

E Estreptococo A

Respuesta C. Fiebre, faringitis exudativa, adenopatías cervicales y esplenomegalia en un adolescente: mononucleosis clásica por VEB. La esplenomegalia descarta la faringitis estreptocócica; el CMV cursa con faringitis mínima o ausente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 152

Una paciente de 18 años, sin antecedentes, consulta por cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, coriza y odinofagia. Al examen físico destacan amígdalas aumentadas de tamaño con exudado blanquecino adherente, adenopatías cervicales, examen pulmonar normal y abdominal con hepatoesplenomegalia. Se solicitan exámenes que muestran lo siguiente: IgM VCA (+), IgG VCA (-), IgM CMV (-), IgG CMV (+), ELISA VIH (-). **El diagnóstico más probable es:**

A Primoinfección por VIH

B Mononucleosis por Citomegalovirus

C Mononucleosis por Virus Epstein Barr

D Síndrome mononucleósico por estreptococo pyogenes

E Síndrome mononucleósico por leucemia aguda

Respuesta C. IgM VCA positiva con IgG VCA negativa indica infección aguda por VEB. Para CMV, IgG positiva con IgM negativa solo indica infección antigua.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Joven de 19 años con fiebre de 38,5 °C, dolor faríngeo intenso y astenia de 6 días. Hace 3 días le diagnosticaron amigdalitis aguda e indicaron amoxicilina 500 mg cada 8 horas. Tras la cuarta dosis presenta exantema maculopapular eritematoso difuso en tronco y extremidades. Al examen: grandes exudados amigdalinos blanquecinos, adenopatías laterocervicales posteriores sensibles de 2 cm y bazo palpable a 3 cm del reborde costal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Cambiar a azitromicina y rotular alergia a penicilina

B Suspender la amoxicilina, pedir hemograma y Monotest, e indicar reposo sin deportes de contacto

C Aumentar la dosis de amoxicilina por falla terapéutica

D Hospitalizar para penicilina sódica endovenosa

E Solicitar tomografía de cuello por sospecha de absceso periamigdalino

Respuesta B. Faringitis exudativa + adenopatías cervicales posteriores + esplenomegalia + exantema tras amoxicilina: mononucleosis por VEB. Se suspende la amoxicilina (el exantema no es alergia verdadera), se confirma con hemograma (linfocitos atípicos > 10%) y anticuerpos heterófilos o IgM anti-VCA, y se indica reposo relativo 3 a 4 semanas sin deportes de contacto por riesgo de rotura esplénica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 54

Un paciente de 23 años consulta por fiebre de 7 días de evolución asociada a odinofagia intensa y malestar general. Al examen físico se observa paciente febril, con temperatura: 38,1 °C, frecuencia cardíaca: 100 por minuto y presión arterial: 118/78 mmHg; presenta faringe eritematosa con amígdalas aumentadas de tamaño, se palpan adenopa ` as cervicales anteriores bilaterales y, en el examen abdominal, se palpa el hígado 2 cm por debajo del reborde costal. Se solicitan exámenes, destacando: hemograma con hematocrito 39%, hemoglobina 13 g/dL, VCM 88 fL, glóbulos blancos 15.600/mm³ con 70% linfocitos, 20% neutrófilos y 10% monocitos; pruebas hepáticas con SGOT: 262 U/L, SGPT: 214 U/L, GGT: 90 U/L, fosfatasas alcalinas: 95 U/L y bilirrubina total: 1,2 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Infección por virus hepa22s A

B Leucemia aguda

C Toxoplasmosis aguda

D Mononucleosis infecciosa

E Amigdali2s bacteriana

Respuesta D. Tiene una mononucleosis clásica, con el síndrome mononucleósico (odinofagia, adenopatías y fiebre), más los elementos clásicos: linfocitosis, hepatoesplenomegalia y hepaGGs (faltó el rash morbiliforme espontáneo o posterior al uso de aminopenicilinas).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 169

Paciente 18 años con +7 días? faringe eritematosa, adenopatías, múltiples consultas por el cuadro, le dieron amoxicilina. Al examen físico persiste con adenopatías, tenía un exantema rosado??. Conducta: a. Solicitar Elisa VIH

B IGM anti cápside epstein barr

B Hemograma y VHS

C Ecografía

D Radiografía

E TAC con contraste

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: IGM anti cápside epstein barr (opción B). 90% de las amigdalitis son virales → tratamiento sintomático. Solo las bacterianas requieren antibióticos.

▶ VER CLASE 1.04.1.026 **Toxicoinfección alimentaria** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 2.4 · Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera

QUÉ HAY QUE SABER

- El tiempo de incubación orienta: <6 h toxina preformada (S. aureus en mayonesa casera o cremas; B. cereus en arroz recalentado), vómitos incoercibles sin fiebre.
- 8–16 h: toxina producida en el intestino (C. perfringens en carnes y guisos recalentados), cólico y diarrea acuosa sin vómitos.
- >16–48 h: invasión bacteriana (Salmonella en huevos, pollo y mayonesa; Campylobacter), con fiebre, dolor y a veces disentería.
- Tratamiento: rehidratación oral o EV y antieméticos (ondansetrón); sin antibióticos en cuadros por toxina. Disentería por Campylobacter: azitromicina (alta resistencia a quinolonas).
- Brote (2 o más personas con la misma comida): notificar a la SEREMI de Salud ante la sola sospecha (vigilancia activa). Seguimiento: controlar hidratación hasta la resolución, habitualmente en 24–72 h.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 76

Paciente con diarrea disentérica aguda y panel gastrointestinal positivo para Campylobacter. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Ciprofloxacino oral por 3 días

B Metronidazol oral por 7 días

C Cotrimoxazol oral por 5 días

D Amoxicilina oral por 7 días

E Azitromicina vía oral

Respuesta E. Campylobacter es un germen invasor: la disentería justifica antibiótico, y el de elección es la azitromicina oral. Las quinolonas tienen alta resistencia en Campylobacter.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Cuatro miembros de una familia consultan en urgencias por náuseas y vómitos profusos de inicio explosivo hace 3 horas. Almorzaron hace 4 horas pastel de choclo y ensalada rusa con mayonesa casera preparada la noche anterior. Ninguno tiene fiebre ni diarrea. Examen: deshidratación leve y dolor epigástrico por los esfuerzos de vómito. **¿Cuál es el agente más probable y la conducta adecuada?**

A Salmonella enteritidis; ciprofloxacino por 5 días

B Staphylococcus aureus; rehidratación y antieméticos, sin antibióticos

C Clostridium perfringens; metronidazol oral

D Staphylococcus aureus; cloxacilina oral por 7 días

E Vibrio cholerae; doxiciclina 300 mg en dosis única

Respuesta B. Incubación de 1 hora, vómitos predominantes, sin fiebre y mayonesa casera: enterotoxina preformada de S. aureus. Tratamiento de soporte (rehidratación oral fraccionada o cristaloides EV y ondansetrón). No se usan antibióticos: el cuadro lo causa una toxina ya formada y cede en 24 horas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 52 años con diplopía, ptosis y disfagia de inicio progresivo hace 24 horas, a lo que se agrega debilidad de extremidades superiores. Comió conservas caseras de espárragos el día anterior. Examen: ptosis bilateral, midriasis arreactiva y tetraparesia flácida simétrica con reflejos disminuidos. Sensibilidad normal, afebril. **¿Cuál es la conducta terapéutica inmediata?**

A Iniciar plasmaféresis por sospecha de síndrome de Guillain-Barré

B Hospitalizar en UCI, monitorizar mecánica ventilatoria y administrar antitoxina botulínica

C Administrar ceftriaxona 2 g EV por sospecha de meningitis bacteriana

D Indicar piridostigmina oral por probable crisis miasténica

E Administrar bolo de metilprednisolona EV por sospecha de esclerosis múltiple

Respuesta B. Conserva casera + pares craneanos + midriasis + parálisis flácida descendente sin compromiso sensitivo: botulismo. UCI por riesgo de falla ventilatoria y antitoxina botulínica precoz. El Guillain-Barré asciende y la miastenia no da midriasis ni disautonomía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 45

Paciente adulto con dolor abdominal, diarrea + fiebre x campylobacter, ¿cual es el tratamiento?: a. Azitromicina

B Hidratacion + probioticos

C Ciprofloxacino

C Staphylococcus aureus

D Streptococcus pneumoniae

E Escherichia coli

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: (opción A).

▶ VER CLASE **1.04.1.027** **Triquinosis** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 4.4 · Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Triquinosis (Trichinella spiralis): consumo de carne de cerdo o cecinas caseras (longanizas, jamón) faenadas sin inspección veterinaria; las larvas migran al músculo estriado.
- Tríada clásica: edema bipalpebral bilateral (a veces con hemorragias subconjuntivales), mialgias intensas (al masticar, tragar o respirar) y fiebre alta persistente.
- Confirmación: eosinofilia masiva (20–50 %) con CPK y LDH elevadas; serología específica apoya. Diferencial con Chagas agudo (edema palpebral unilateral).
- Tratamiento: albendazol 400 mg c/12 h por 10–14 días (o mebendazol) más analgesia; agregar corticoides si es severa (miocarditis o compromiso sistémico).
- Notificación obligatoria inmediata a la SEREMI para decomisar el alimento y estudiar a los demás expuestos. Seguimiento: control clínico y de CPK y eosinófilos; vigilar miocarditis.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 56

Un paciente de 25 años que vive en una zona rural consulta por cefalea y mialgias intensas de 7 días de evolución, asociadas a malestar general y sensación febril. Al examen físico presenta temperatura: 37,5 °C, frecuencia cardíaca: 115 por minuto y presión arterial: 100/60 mmHg. Se solicitan exámenes que muestran PCR 5,6 mg/L (valor normal: menor a 0,5 mg/dl), hemograma con 15.000 glóbulos blancos/mm³, 290.000 plaquetas/mm³ y hematocrito de 35%. En la fórmula diferencial de la serie blanca presenta 40% de eosinófilos. Se solicitan CK, que resultan 2.500 U/L (VN: 30-170 U/L). El estudio ecocardiográfico es compatible con miocarditis aguda. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Fasciolasis hepática
B Neurocisticercosis
C Hidatidosis
D Infección por Trichinella spiralis
E Infección por virus Coxsackie

Respuesta D. Mialgias + eosinofilia masiva + CK elevada: triquinosis clásica, aquí con miocarditis. Se trata con albendazol y analgésicos, y por la miocarditis se agregan corticoides. El Coxsackie da miocarditis, pero no eosinofilia.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 44 años con 4 días de fiebre de 39 °C, mialgias severas en brazos y piernas que le dificultan caminar y masticar, e hinchazón de ojos. Hace 10 días comió carne de cerdo y longanizas artesanales faenadas en el campo. Edema bipalpebral bilateral con hiperemia conjuntival y dolor a la palpación muscular. Leucocitos 16.200/mm³ con 42% de eosinófilos; CPK 890 UI/L. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Notificar a la SEREMI e iniciar albendazol 400 mg cada 12 horas por 10 a 14 días
B Solicitar ecografía abdominal y serología para hidatidosis
C Iniciar nifurtimox por sospecha de Chagas agudo
D Iniciar ceftriaxona endovenosa por fiebre tifoidea
E Solo analgesia y control en una semana

Respuesta A. Cecinas caseras sin inspección + edema bipalpebral bilateral + mialgias + fiebre + eosinofilia masiva y CPK alta: triquinosis aguda. Se notifica de inmediato (ENO) y se trata con albendazol 400 mg cada 12 h por 10 a 14 días. El Chagas agudo da edema unilateral.

▶ VER CLASE 1.04.1.028 Tuberculosis extrapulmonar

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.3 · Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR

QUÉ HAY QUE SABER

- TBC extrapulmonar: 20–25 % de los casos, más del 50 % en VIH; la radiografía de tórax normal no la descarta. Formas más frecuentes: ganglionar y pleural.
- Pleural: exudado unilateral con más de 80 % de linfocitos y ADA >40 UI/L. Ganglionar (escrófula): adenopatías cervicales indoloras y frías que coalescen y fistulizan.
- Meníngea: cuadro subagudo con compromiso de pares III y VI; LCR con linfocitos, glucosa muy baja y proteínas muy altas. Mal de Pott: lumbago o dorsalgia inflamatoria con VHS alta; estudiar con RM.
- Urogenital: piuria estéril con orina ácida y hematuria; cultivo de Koch en orinas matinales seriadas. Confirmar con baciloscopía, cultivo (estándar de oro, da antibiograma), GeneXpert o biopsia.
- Esquema nacional 2RHZE/4RH directamente observado (las formas meníngea y osteoarticular se prolongan). Seguimiento: derivar al Programa de Tuberculosis; vigilar hepatotoxicidad y neuritis óptica por etambutol.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 71

Un paciente de 35 años, sin antecedentes, con cuadro de una semana de compromiso del estado general y sensación febril, que durante los últimos días se agrega cefalea y diplopía. Al examen físico destaca reflejo fotomotor conservado, parálisis del sexto par derecho y rigidez de nuca esbozada. Se solicita punción lumbar que muestra células aumentadas de predominio mononuclear, glucosa disminuida y proteínas altas, gram no visualiza gérmenes. **El agente etiológico más probable en este caso es:**

A Mycobacterium tuberculosis
B Neumococo
C Enterovirus
D Herpes virus
E Criptococosis

Respuesta A. Cuadro subagudo con compromiso de pares craneanos (VI par) y LCR con mononucleares, glucosa baja y proteínas altas: meningitis tuberculosa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 116

Un paciente de 54 años, con antecedente de artritis reumatoide severa, inicia tratamiento con corticoides sistémicos y terapia biológica, por lo que se realiza estudio de tuberculosis latente con PPD, el que resulta positivo, indicándose tratamiento con isoniacida por 6 meses, permaneciendo asintomático. Un año después consulta por lumbago muy intenso, EVA 8/10, de 10 días de evolución, que ha empeorado en los últimos días y no ha respondido a analgésicos. En el examen físico el dolor limita los movimientos de flexoextensión. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 30% con hemoglobina: 10 g/dL, glóbulos blancos: 12.000/mm³, plaquetas: 480.000/mm³ y VHS: 80 mm/h. La radiografía de tórax es normal. **¿Cuál es el examen más adecuado para evaluar a este paciente?**

A Radiografía de columna lumbar

B Resonancia magnética nuclear lumbar

C Cintigrafía ósea

D ELISPOT

E PET-scan

Respuesta B. Inmunosuprimido con TBC latente conocida, lumbago intenso refractario y VHS 80: sospecha de mal de Pott (espondilodiscitis tuberculosa). Como osteomielitis, el examen de elección es la RM. El ELISPOT es un IGRA, útil en la TBC latente, no para evaluar la columna.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 91

Paciente con VIH sin TARV, fiebre, baja de peso, hemoptisis, baciloscopías negativas y cultivo MGIT positivo. **¿Cuál es la conducta?**

A Iniciar TARV e investigar otras infecciones oportunistas

B Solicitar broncoscopía y biopsia transbronquial

C Iniciar profilaxis con isoniazida y observar

D Repetir baciloscopías y esperar resultado de cultivo

E Iniciar tratamiento estándar para tuberculosis

Respuesta E. El cultivo es el gold standard: un cultivo MGIT positivo confirma tuberculosis activa aunque las baciloscopías sean negativas. Corresponde el esquema estándar, no la profilaxis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 118

Un paciente es diagnosticado de tuberculosis pulmonar, por lo que se inicia tratamiento con antibióticos asociados. Sus baciloscopías mensuales de control resultan: mes 1 (+), mes 2 (-), mes 3 (-), mes 4 (-), mes 5 (+) y mes 6 (+). **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Recaída

B Eliminación esporádica

C Fracaso

D Contaminación

E Nocardiosis pulmonar

Respuesta C. Dos baciloscopías positivas seguidas después del cuarto mes, estando aún en tratamiento, hacen sospechar fracaso. Se confirma con cultivo y antibiograma, y el paciente se deriva a tratamiento secundario mientras tanto.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 8

Un paciente de 42 años consulta por tos y disnea de 2 semanas de evolución, asociada a expectoración mucopurulenta y, en ocasiones, hemoptoica. Además, ha presentado fiebre ocasional, hasta 38,2°C. Al examen físico presenta estertores bilaterales en ambos campos pulmonares. Se solicitaron baciloscopías de expectoración, que resultan negativas. Además, se solicita otros exámenes, que muestran quantiferón para tuberculosis (+) y PCR para Mycobacterium tuberculosis (+). Su radiografía de tórax se muestra más abajo. **La conducta más adecuada es:**

A Iniciar profilaxis con isoniazida

B Iniciar rifampicina más isoniazida

C Iniciar tratamiento habitual para la tuberculosis

D Solicitar TAC de tórax

E Esperar el resultado del cultivo de Koch y decidir conducta según resultado

Respuesta C. La PCR positiva para M. tuberculosis confirma la enfermedad aunque las baciloscopías sean negativas. Se inicia el tratamiento habitual (esquema primario RHZE). La profilaxis es para contactos sin enfermedad activa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 21

Paciente de 35 años VIH (+) con tos productiva de 3 semanas, baja de peso y sudoración nocturna. Baciloscopia de esputo positiva. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A Isoniazida + Rifampicina + Pirazinamida + Etambutol por 2 meses, luego Isoniazida + Rifampicina por 4 meses

B Claritromicina + Etambutol por 6 meses

C Moxifloxacino + Rifampicina por 9 meses

D Isoniazida en monoterapia por 9 meses

E Cotrimoxazol forte por 6 meses

Respuesta A. TBC pulmonar activa: esquema 2 HRZE + 4 HR, 6 meses en total, independiente del estado VIH.

▶ VER CLASE **1.04.1.029** **Enfermedad leve moderada por SARS Cov 2 COVID 19** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.6 · Virus Respiratorios: Influenza y COVID-19 (Adulto y Niño)

QUÉ HAY QUE SABER

- COVID-19 leve: fiebre, tos, odinofagia, mialgias, cefalea y anosmia o ageusia, sin disnea ni hipoxemia; moderado si hay neumonía con saturación ≥94 %.
- Confirmación: PCR o test de antígeno en hisopado nasofaríngeo, idealmente en los primeros días de síntomas.
- Tratamiento ambulatorio sintomático: paracetamol, hidratación y reposo; no usar corticoides ni antibióticos sin hipoxemia. Antivirales orales solo en pacientes de alto riesgo según disponibilidad.
- Aislamiento según normativa vigente y educación de signos de alarma: disnea, saturación <94 %, dolor torácico, compromiso de conciencia; especial vigilancia en adultos mayores, inmunosuprimidos y enfermos crónicos.
- Seguimiento: control a distancia en grupos de riesgo, sobre todo entre los días 5 y 10; prevención con vacunación según calendario del PNI.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 30 años, sin comorbilidades y con esquema de vacunación completo, presenta fiebre, odinofagia, tos seca y mialgias de 2 días. El test de antígeno para SARS-CoV-2 es positivo. Saturación 98%, FR 16 por minuto, examen pulmonar normal. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Hospitalizar e iniciar dexametasona

B Manejo ambulatorio sintomático, aislamiento y educación sobre signos de alarma

C Azitromicina por 5 días

D Ivermectina

E TAC de tórax y anticoagulación

Respuesta B. COVID-19 leve en un paciente sin factores de riesgo ni hipoxemia se maneja en domicilio con antipiréticos, hidratación, aislamiento y educación sobre signos de alarma (disnea, saturación bajo 94%, compromiso de conciencia). La dexametasona solo beneficia a quienes requieren oxígeno y puede dañar sin hipoxemia. Antibióticos e ivermectina no están indicados.

Situaciones clínicas de urgencia

11 códigos

▶ VER CLASE **1.04.2.001** **Absceso cerebral** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.3 · Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

QUÉ HAY QUE SABER

- Absceso cerebral: infección focal supurada del parénquima. Origen por contigüidad en 50 % (sinusitis, otitis crónica, mastoiditis), hematógeno en 30 % (cardiopatía cianótica, endocarditis) o por inoculación directa (TEC penetrante, neurocirugía).
- Sospecha: cefalea, fiebre y déficit focal (la fiebre falta en la mitad), a veces convulsiones; el foco predice la ubicación (seno frontal: lóbulo frontal; oído: temporal o cerebelo).
- Diagnóstico: TAC o RM con contraste muestra lesión con realce en anillo y edema perilesional. Punción lumbar contraindicada por riesgo de herniación.
- Inicial: ceftriaxona 2 g c/12 h EV más metronidazol 500 mg c/8 h EV; agregar vancomicina si hubo trauma o neurocirugía.
- Derivar a neurocirugía: drenaje o aspiración estereotáxica si mide más de 2,5 cm. Seguimiento: por especialista.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años con una sinusitis frontal mal tratada hace 3 semanas consulta por cefalea progresiva, fiebre de 38 °C y paresia del brazo derecho. La TAC de cerebro con contraste muestra una lesión frontal izquierda hipodensa, con captación de contraste en anillo y edema perilesional. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Aciclovir endovenoso

B Corticoides en monoterapia

C Punción lumbar inmediata para cultivo

D Radioterapia por sospecha de glioblastoma

E Ceftriaxona y metronidazol endovenosos, más evaluación neuroquirúrgica para drenaje

Respuesta E. Lesión con captación en anillo, fiebre y un foco contiguo como la sinusitis es un absceso cerebral. Se trata con antibióticos endovenosos que cubran estreptococos y anaerobios, como ceftriaxona más metronidazol, y aspiración o drenaje neuroquirúrgico. La punción lumbar está contraindicada por el efecto de masa.

▶ VER CLASE **1.04.2.002** **Encefalitis aguda** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.3 · Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

QUÉ HAY QUE SABER

- Encefalitis: fiebre con alteración de la función cerebral (conducta bizarra, desinhibición, alteración de memoria, afasia, crisis convulsivas focales); signos meníngeos ausentes o leves. El VHS-1 es la causa esporádica más frecuente.
- Pistas temporales: alucinaciones olfatorias o gustativas, afasia de comprensión, crisis focales.
- Confirmación: RM de elección (hiperintensidad temporal en T2/FLAIR; la TAC puede ser normal las primeras 48–72 h); LCR con pleocitosis linfocítica, glucosa normal y eritrocitos; PCR para VHS en LCR (sensibilidad y especificidad >95 %).
- Inicial: aciclovir EV 10 mg/kg c/8 h ante la sospecha, sin esperar RM ni PCR (14–21 días); reduce la mortalidad de >70 % a <20 %. Los antibióticos solos no cubren el virus.
- Si hay convulsiones, focalidad o compromiso de conciencia, TAC antes de puncionar sin retrasar el aciclovir. Seguimiento: derivar y hospitalizar (idealmente UCI).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 100

Un paciente de 43 años, presenta un cuadro clínico de fiebre de 4 días de evolución, asociado a cefalea. Hoy se agrega desorientación y confusión, convulsionando en dos oportunidades antes de consultas. La TAC de cerebro muestra una zona hiperdensa en el lóbulo temporal izquierdo. Se realiza punción lumbar, con 130 células por mm3, 85% mononucleares, glucosa: 75 mg/dl (glicemia 90 mg/dl), proteínas 100 mg/dl, con Pandy (+), látex negativo y ausencia de bacterias en la tinción de Gram. Los cultivos están pendientes. **El diagnóstico más probable es:**

A Meningitis bacteriana aguda
B Meningitis tuberculosa
C Meningoencefalitis herpética
D Meningitis por enterovirus
E Meningitis por VIH

Respuesta C. Compromiso de conciencia y convulsiones con lesión del lóbulo temporal y LCR viral (mononucleares, glucosa normal): meningoencefalitis herpética.

▶ VER CLASE 1.04.2.003 Endocarditis bateriana

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 4.5 · Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Endocarditis infecciosa: sospechar ante fiebre con soplo nuevo, sobre todo en valvulopatía o prótesis, usuarios de drogas EV, portadores de dispositivos o catéteres, o bacteriemia por S. aureus.
- Signos asociados: fenómenos embólicos (ACV, infartos esplénicos o renales), hemorragias en astilla, lesiones de Janeway, nódulos de Osler, manchas de Roth e insuficiencia cardíaca aguda por destrucción valvular.
- Diagnóstico por criterios de Duke: mayores, hemocultivos positivos para germen típico (S. aureus, estreptococos viridans, enterococo) y evidencia ecocardiográfica de vegetación, absceso o nueva insuficiencia valvular.
- Inicial: 3 sets de hemocultivos de sitios distintos antes del antibiótico, ecocardiograma (transtorácico y luego transesofágico) y antibiótico empírico EV si está grave (por ejemplo ampicilina + cloxacilina + gentamicina; vancomicina si es protésica o hay riesgo de SAMR).
- Derivar y hospitalizar: tratamiento EV prolongado (4–6 semanas); la cirugía se indica por insuficiencia cardíaca, absceso, infección no controlada o embolías recurrentes.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 123

Un paciente de 51 años, con antecedente de un recambio valvular secundario a una valvulopatía, consulta por un cuadro de 2 semanas de astenia, fiebre y malestar general. Al examen físico tiene T° 38,2 °C, PA 120/80 mmHg y FC 94 por minuto; se observan lesiones eritematosas en los dedos de ambas manos y algunas petequias en las extremidades inferiores, y en el examen cardíaco se ausculta un soplo diastólico de intensidad IV/VI. En los exámenes destaca PCR 12 mg/L, VHS 70 mm/h y leucocitosis de 16.000/mm³. Se realizan 3 hemocultivos, que resultan todos positivos para cocáceas grampositivas en cadena. **¿Cuál es el antibiótico de elección para iniciar el tratamiento?**

A Penicilina sódica
B Cloxacilina
C Clindamicina
D Ceftazidima
E Gentamicina

Respuesta A. Endocarditis subaguda en una prótesis valvular tardía con cocáceas grampositivas en cadena (estreptococos del grupo viridans) se trata con penicilina sódica (o ceftriaxona) endovenosa por 6 semanas, a la que puede asociarse gentamicina. La cloxacilina es para estafilococos (cocos en racimos) y la gentamicina sola no es tratamiento.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 136

Paciente operado de válvula cardíaca hace 2 meses. Presenta fiebre, soplo cardíaco nuevo y hemocultivos positivos. ¿Cuál es el agente más probable en endocarditis infecciosa post-cirugía cardíaca precoz?

A Staphylococcus aureus o S. epidermidis

B Streptococcus viridans

C Enterococcus faecalis

D HACEK group

E Candida albicans

Respuesta A. Endocarditis protésica precoz (<2 meses post-cirugía): causada por gérmenes hospitalarios, principalmente Staphylococcus aureus y S. epidermidis (estafilococos coagulasa negativos), adquiridos intraoperatoriamente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 115

Paciente masculino de 45 años, presenta súbitamente hemiparesia derecha, refiere historia de 2 meses de evolución de astenia, compromiso del estado general y fiebre de predominio nocturno. Al examen físico presenta hemiparesia derecha, fiebre de 37,8 grados celsius y la auscultación cardiaca muestra un ritmo regular en 2 tiempos, con un soplo sistólico IV/VI en el ápex. Su sedimento de orina muestra hematuria microscópica. El diagnóstico más probable es:

A Absceso cerebral

B Tuberculosis meníngea

C Meningitis bacteriana

D Endocarditis bacteriana

E Leucemia mieloide aguda

Respuesta D. Tanto el soplo, como los fenómenos embólicos, orientan a EBSA (endocarditis bacteriana subaguda; la aguda es menor a 7 días). Ninguna de las opciones puede ser, por no tener relación con la clínica.

▶ VER CLASE 1.04.2.004 Flegmón submaxilar, submandibular y del piso de la boca

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.4 · Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

QUÉ HAY QUE SABER

- Angina de Ludwig: celulitis gangrenosa bilateral de los espacios submandibular y sublingual, de origen dental en 80 % (2.º o 3.er molar inferior).
- Sospecha: aumento de volumen submandibular bilateral, piso de boca elevado que empuja la lengua, trismus, voz engolada y estridor.
- El riesgo es la asfixia: lo primero es asegurar la vía aérea (intubación con fibra óptica o traqueostomía); no enviar a TAC sin vía aérea segura.
- Luego antibióticos EV de amplio espectro con cobertura de anaerobios y aseo quirúrgico o drenaje.
- Diferencial: absceso periamigdalino (unilateral, úvula desviada al lado contrario). Seguimiento: derivar de urgencia a cirugía maxilofacial u otorrinolaringología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 38 años con 48 horas de aumento de volumen doloroso cervical anterior y submandibular bilateral, iniciado tras la extracción del tercer molar inferior izquierdo. Al examen: piso de boca elevado que empuja la lengua contra el paladar, trismus moderado, voz engolada y estridor inspiratorio intermitente. T° 38,9 °C. **¿Cuál es la prioridad inmediata?**

A Asegurar la vía aérea mediante intubación con fibra óptica o traqueostomía

B Solicitar TAC de cuello con contraste para planificar el drenaje

C Iniciar amoxicilina con ácido clavulánico oral y analgesia

D Iniciar meropenem, vancomicina y clindamicina EV y observar en sala

E Nebulizar con adrenalina y controlar en 12 horas

Respuesta A. Celulitis bilateral submandibular y sublingual de origen dental con estridor y lengua protruida: angina de Ludwig con riesgo inminente de asfixia. Lo primero es asegurar la vía aérea (fibra óptica o traqueostomía); después, aseo quirúrgico y antibióticos EV.

▶ VER CLASE 1.04.2.005 Infección invasiva de partes blandas: celulitis, fasceitis, miositis necrotizantes o septicémicas

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.4 · Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

QUÉ HAY QUE SABER

- Fascitis necrotizante: tipo I polimicrobiana (80 %, diabéticos o cirugía perineal; Fournier en el periné) y tipo II por S. pyogenes (jóvenes, trauma menor o varicela).
- Signo precoz: dolor desproporcionado a lo que se ve en la piel, que sobrepasa el borde del eritema. Signos duros: flictenas serohemáticas, crepitación, anestesia cutánea focal y shock séptico.
- Conducta: pabellón inmediato (aseo quirúrgico, fasciotomía y desbridamiento) basado solo en la sospecha clínica; no retrasar por TAC o RM.
- Antibióticos EV en paralelo: meropenem + vancomicina + clindamicina (bloquea la síntesis de toxinas), con reanimación del shock.

- Celulitis simple sin signos duros: cefazolina o cloxacilina EV, marcar el borde del eritema y reevaluar en 12–24 h. Seguimiento: derivar a cirugía.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 172

Un paciente de 53 años, diabético mal controlado, presenta una lesión en la pierna derecha, desde hace 2 días, que se ha extendido hasta alcanzar un gran tamaño y se ha asociado a malestar general y fiebre. Al examen físico tiene T°: 39,0°C, FC: 115x', PA: 90/60 mmHg. Además, se aprecia la lesión eritematosa de 20 cm, con zonas violáceas y bulas en su superficie. **El diagnóstico más probable es:**

A Erisipela
B Herpes zóster
C Pioderma gangrenoso
D Fasceítis necrotizante
E Celulitis bacteriana

Respuesta D. Diabético con lesión extensa, zonas violáceas y bulas, más taquicardia e hipotensión: signos de necrosis con compromiso sistémico. Es una fascitis necrotizante, no una celulitis ni una erisipela.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 135

Un paciente de 48 años, diabético mal controlado, presenta una lesión en el muslo derecho, desde hace 5 días, que ha crecido y se ha asociado a malestar general y fiebre. Al examen físico tiene T°: 39,0°C, FC: 115x', PA: 90/60 mmHg y se aprecia la lesión de 20 cm de aspecto eritemato-violáceo, con bulas en su superficie. El diagnóstico más probable es:

A Erisipela
B Herpes zóster
C Ántrax
D Fasceítis necrotizante
E Miositis necrotizante

Respuesta D. Diagnóstico: Fasceítis necrotizante (opción D). Es una fasceítis necrotizante clásica.

▶ VER CLASE 1.04.2.006 Meningitis aguda

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.2 · Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

QUÉ HAY QUE SABER

- Meningitis bacteriana: tríada fiebre, cefalea y rigidez de nuca (completa en menos del 50 %); Kernig y Brudzinski, fotofobia y vómitos. Agentes: neumococo y meningococo (petequias o púrpura).
- TAC antes de la punción solo si hay déficit focal, convulsión reciente, Glasgow <10, papiledema o inmunodepresión; en ese caso hemocultivos, dexametasona y antibióticos van antes de la imagen.
- LCR bacteriano: >1.000 leucocitos con >80 % PMN, glucosa LCR/suero <0,4 y proteínas 100–500 mg/dL. Viral: mononucleares, glucosa normal (>0,6). TBC: linfocitos, glucosa muy baja y proteínas muy altas.
- Empírico (3 meses a 50 años): dexametasona 10 mg c/6 h EV por 4 días (antes o junto al antibiótico) + ceftriaxona 2 g c/12 h + vancomicina 15–20 mg/kg c/12 h. Mayores de 50, embarazadas o inmunodeprimidos: agregar ampicilina 2 g c/4 h por Listeria.
- Meningococo: notificación inmediata y profilaxis de contactos. Seguimiento: derivar y hospitalizar.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 37

Mujer de 23 años, con cuadro de 24 horas de evolución de compromiso del estado general, fiebre y soñolencia progresiva. Al examen físico destaca con temperatura de 38,5ºC, petequias y equimosis en extremidades, rigidez de nuca sin focalización neurológica. **El diagnóstico más probable es:**

A Meningitis tuberculosa
B Meningitis meningococica
C Meningitis neumocócica
D Meningitis por listeria
E Meningitis herpética

Respuesta B. Cuadro de meningitis bacteriana aguda en una joven. Las petequias y equimosis orientan a meningococcemia: Neisseria meningitidis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 81

Un paciente de 65 años, consulta por fiebre y cefalea de 3 días de evolución, a lo que luego se agrega desorientación. Al examen físico se aprecia confuso, con temperatura 38,5 grados Celsius, FC: 95x' y PA: 110/70 mmHg. En su examen neurológico se aprecia rigidez de nuca, por lo que realiza punción lumbar, que da salida a un líquido cefalorraquídeo con 610 células por mm3, con 90% de polimorfonucleares, glucosa: 26 mg/dl y proteínas 123 mg/dl. Además, la tinción de Gram muestra visualización de diplococos gramnegativos. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A Ceftriaxona endovenosa
B Cloxacilina endovenosa
C Vancomicina endovenosa
D Imipenem endovenoso
E Ciprofloxacino oral

Respuesta A. LCR bacteriano con diplococos gramnegativos en el Gram: meningococo. Se trata con ceftriaxona endovenosa. El Gram ya identificó el agente, por lo que no se trata de un esquema empírico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 61

Un paciente consulta por 5 días de cefalea holocránea intensa, asociada a fiebre hasta 38 grados. En su examen físico se aprecia rigidez de nuca y signo de Brudzinsky esbozados, por lo que se realiza punción lumbar, que da salida a un líquido con 60 células por mm3, 86% mononucleares, glucorraquia: 0,67 y proteínas de 66 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Meningitis bacterial
B Encefalitis herpética
C Meningitis viral
D Tuberculosis meníngea
E Infección por Listeria monocytogenes

Respuesta C. Pleocitosis moderada mononuclear, razón de glucosa normal (0,67) y proteínas levemente elevadas: meningitis viral. No hay compromiso de funciones cerebrales que sugiera encefalitis herpética.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 54 años con 24 horas de cefalea holocránea, fiebre de 39,2 °C, fotofobia y vómitos. Glasgow 14, sin focalidad, fondo de ojo normal, rigidez de nuca y Brudzinski (+). PL inmediata: LCR turbio, presión 32 cm H_2O, 4.200 leucocitos/mm^3 (92 % PMN), glucosa 18 mg/dL (glicemia 110 mg/dL), proteínas 280 mg/dL. **¿Cuál es el tratamiento empírico más adecuado?**

A Ceftriaxona + vancomicina EV
B Dexametasona + ceftriaxona + vancomicina + ampicilina EV
C Aciclovir EV
D Ceftriaxona EV en monoterapia
E Esperar el cultivo del LCR para iniciar antibióticos

Respuesta B. Citoquímico bacteriano típico (PMN > 80 %, razón de glucosa < 0,4, proteínas muy altas). Por ser mayor de 50 años se agrega ampicilina para cubrir Listeria, junto con dexametasona precoz y ceftriaxona + vancomicina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 130

Una paciente de 25 años presenta un cuadro de cefalea holocránea y fiebre alta. Al examen físico presenta rigidez de nuca y signo de Brudzinsky, con petequias en extremidades inferiores, asociadas a algunas equimosis. El agente causal más probable es:

A Neisseria meningitidis
B Streptococcus pneumoniae
C Haemophilus influenzae
D Listeria monocytogenes
E Viris herpes simplex

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Neisseria meningitidis). Cuadro clásico de meningococcemia. Esta clase revisa el diagnóstico y manejo de la meningitis bacteriana, viral y tuberculosa.

▶ VER CLASE 1.04.2.007 Sepsis y shock séptico

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.1 · Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sepsis (Sepsis-3): infección con disfunción orgánica, aumento agudo del SOFA ≥2. El SIRS ya no define la sepsis.
- qSOFA para alarma en la cabecera (≥2 de 3): FR ≥22, Glasgow <15, PAS ≤100 mmHg. Shock séptico: necesidad de vasopresor para PAM ≥65 y lactato >2 mmol/L pese a volumen adecuado (mortalidad >40 %).
- Primera hora: lactato, 2 hemocultivos de sitios distintos (sin retrasar el antibiótico), antibióticos EV de amplio espectro según foco y cristaloides 30 mL/kg si hay hipotensión o lactato ≥4.
- Si persiste PAM <65 tras volumen: noradrenalina (primera línea, puede iniciarse por vía periférica); dopamina proscrita. Refractario: vasopresina y hidrocortisona 200 mg/día; dobutamina si hay falla de bomba.

- Repetir lactato a las 2–4 h (meta: descenso >20 %); cada hora de retraso del antibiótico aumenta la mortalidad. Seguimiento: derivar a UCI.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años con ITU complicada febril (39 °C), soporoso, PA 82/48 (PAM 59 mmHg), FC 122 lpm, FR 26 rpm. Se administran 2.500 mL de Ringer lactato (30 mL/kg) en 2 horas. Tras la carga, la PA es 84/50 mmHg (PAM 61 mmHg) y el lactato 4,2 mmol/L. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Iniciar noradrenalina EV con meta de PAM ≥ 65 mmHg

B Iniciar dopamina EV en infusión continua

C Administrar hidrocortisona EV antes de cualquier vasopresor

D Repetir otra carga de 2.500 mL de cristaloides

E Esperar el resultado de los hemocultivos para ajustar el tratamiento

Respuesta A. Shock séptico de foco urinario: tras 30 mL/kg persiste PAM < 65 mmHg con lactato > 2 mmol/L. Se inicia noradrenalina EV (meta PAM ≥ 65), junto con hemocultivos y antibióticos de amplio espectro. La dopamina está proscrita y la hidrocortisona se reserva para el shock refractario a noradrenalina.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos forma parte del score qSOFA (quick SOFA) para la identificación rápida de sepsis en el servicio de urgencia? **¿Qué parámetro pertenece al qSOFA?**

A Temperatura axilar > 38,3 °C o < 36,0 °C

B Leucocitosis > 12.000/mm³ o baciliformes > 10 %

C Frecuencia respiratoria ≥ 22 respiraciones por minuto

D Frecuencia cardíaca > 90 latidos por minuto

E Diuresis horaria < 0,5 mL/kg/h

Respuesta C. El qSOFA tiene solo tres parámetros clínicos, sin laboratorio: FR ≥ 22 rpm, alteración de conciencia (Glasgow < 15) y PAS ≤ 100 mmHg. Temperatura, taquicardia y leucocitosis eran criterios del antiguo SIRS, abandonado por inespecífico.

▶ VER CLASE 1.04.2.008 Síndrome pulmonar por Hanta Virus

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 4.1 · Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SCPH)

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome cardiopulmonar por hantavirus (virus Andes): inhalación de excretas secas del ratón colilargo en recintos rurales cerrados (cabañas, bodegas, leñeras), de Coquimbo a Aysén; letalidad 30–35 %.
- Fase prodrómica de 3–6 días: fiebre alta, cefalea y mialgias intensas de muslos y región lumbar, sin coriza. Luego fase cardiopulmonar: tos seca, disnea rápidamente progresiva, edema pulmonar no cardiogénico y shock.
- Tríada del hemograma: plaquetas <100.000, hematocrito >45–50 % (hemoconcentración) e inmunoblastos >10 %; radiografía con infiltrados bilaterales sin cardiomegalia.
- Inicial: oxígeno, restricción hídrica estricta (nunca bolos de 30 mL/kg), noradrenalina precoz para sostener la presión y monitorización.
- Notificación inmediata ante la sospecha y confirmación con IgM específica (sin esperarla para actuar). Derivar en ambulancia medicalizada a centro con ECMO al inicio de la disnea.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 7

Paciente de 28 años llega a urgencias con fiebre alta, cefalea intensa, mialgias, compromiso respiratorio progresivo y antecedente de trabajo en zona rural del sur de Chile. Hemograma con leucopenia y trombocitopenia. **¿Cuál es el agente causal más probable?**

A Hantavirus (Sin Nombre)

B Leptospira interrogans

C Rickettsia conorii

D Yersinia pestis

E Francisella tularensis

Respuesta A. Trabajo rural en el sur de Chile + fiebre, cefalea, mialgias y compromiso respiratorio progresivo + trombocitopenia: hantavirus. En Chile el agente es el virus Andes, transmitido por el ratón colilargo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 38 años, trabajador agrícola del Maule, con 4 días de fiebre de 39 °C, cefalea y mialgias intensas en espalda y muslos; hace 6 horas agrega tos seca y disnea progresiva. Hace 2 semanas limpió una bodega deshabitada. PA 90/60 mmHg, FC 115 lpm, FR 28, SatO2 89 %. Rx: infiltrados alveolares bilaterales sin cardiomegalia. Hto 54 %, leucocitos 18.500 con 14 % de inmunoblastos, plaquetas 42.000. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Bolo de cristaloides 30 mL/kg y ceftriaxona endovenosa

B Notificar, oxígeno, aporte hídrico restrictivo y traslado inmediato a centro con ECMO

C Oseltamivir y hospitalización en sala básica

D Esperar la IgM para hantavirus antes de decidir el traslado

E Transfusión de plaquetas y furosemida en bolo

Respuesta B. Exposición en bodega cerrada + fiebre, mialgias y disnea + tríada (Hto 54 %, plaquetas 42.000, inmunoblastos 14 %): síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Notificación ENO inmediata, oxígeno, aporte hídrico restrictivo y traslado en ambulancia medicalizada a un centro con ECMO. La carga de volumen inunda los alvéolos.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Trabajador forestal de 32 años consulta en un hospital de baja complejidad por 3 días de fiebre alta, dolor muscular severo en muslos y sensación de falta de aire. Hemograma: Hto 52 %, leucocitos 16.000/mm³ con 12 % de inmunoblastos, plaquetas 48.000/mm³. **¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas está contraindicada o debe evitarse?**

A Carga masiva de cristaloides con 30 mL/kg en bolo

B Oxigenoterapia con mascarilla de no reinhalación

C Monitoreo estricto de diuresis horaria

D Traslado en ambulancia avanzada con médico

E Toma de serología para IgM específica

Respuesta A. Síndrome cardiopulmonar por hantavirus: la fuga capilar alveolar hace que los bolos de volumen (como los 30 mL/kg de la sepsis) precipiten un edema pulmonar masivo y asfixia. La guía MINSAL exige manejo hemodinámico restrictivo.

▶ VER CLASE 1.04.2.009 Tétanos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 2.2 · Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico

QUÉ HAY QUE SABER

- Tétanos: C. tetani en heridas desvitalizadas (punzantes, quemaduras, fracturas expuestas); la tetanoespasmina bloquea la liberación de GABA y glicina.
- Sospecha: trismus, risa sardónica, rigidez de cuello y abdomen, opistótonos y espasmos dolorosos desencadenados por luz o ruido, con conciencia conservada y habitualmente sin fiebre.
- Inicial: hospitalizar en UCI en box oscuro y silencioso, asegurar la vía aérea (riesgo de espasmo laríngeo), benzodiazepinas o sedación y relajantes musculares.
- Inmunoglobulina antitetánica humana 3.000–6.000 UI para neutralizar la toxina libre, metronidazol EV (o penicilina) y aseo quirúrgico de la herida.
- La enfermedad no deja inmunidad: iniciar vacunación dT. Seguimiento: derivar a UCI.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años, agricultor sin registro de vacunas, se hirió el pie con una herramienta hace 10 días. Consulta por dificultad para abrir la boca, rigidez de cuello y abdomen, y espasmos dolorosos generalizados que se desencadenan con ruidos. Está lúcido y afebril. **Además del aseo quirúrgico de la herida, ¿cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Inmunoglobulina antitetánica, metronidazol, benzodiazepinas y manejo en UCI, más inicio de la vacunación

B Solo vacuna dT

C Penicilina benzatina y alta

D Fenitoína por crisis convulsivas

E Bloqueo neuromuscular ambulatorio

Respuesta A. Trismus, rigidez y espasmos con conciencia conservada es un tétanos generalizado. Se maneja en UCI: inmunoglobulina antitetánica para neutralizar la toxina libre, metronidazol, benzodiazepinas para los espasmos, control de la vía aérea y ambiente tranquilo. La enfermedad no deja inmunidad, por lo que también se inicia la vacunación.

▶ VER CLASE 1.04.2.010 Varicela complicada: neumonitis, cerebelitis, encefalitis

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.4 · Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster

QUÉ HAY QUE SABER

- Neumonitis varicelosa: la complicación más letal; en adultos, embarazadas y fumadores, entre los días 3 y 5 del exantema, con tos seca, disnea súbita, hipoxemia e infiltrados nodulares difusos bilaterales.
- Cerebelitis (ataxia cerebelosa aguda): la neurológica más común en niños, 1–3 semanas post exantema, con marcha atáxica, dismetría y nistagmo; autolimitada, manejo conservador.

- Encefalitis: compromiso de conciencia, convulsiones o focalidad; requiere aciclovir EV y hospitalización. Sobreinfección bacteriana de las lesiones (la más frecuente en niños) puede llegar a celulitis o fascitis por S. pyogenes.
- Inicial en neumonitis o encefalitis: aciclovir EV 10 mg/kg c/8 h y oxígeno; la vía oral es insuficiente. La inmunoglobulina antivaricela sirve como profilaxis post exposición, no como tratamiento.
- Nunca aspirina (síndrome de Reye); aislamiento aéreo. Seguimiento: derivar a hospitalización, UCI en la neumonitis.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 32 años, sano y no vacunado contra la varicela, con 4 días de fiebre y exantema vesicular pruriginoso con lesiones en distintos estadios en cara y tórax. Hace 12 horas agrega tos seca, disnea de reposo rápidamente progresiva y dolor pleurítico bilateral. T° 38,6 °C, FC 118 lpm, FR 32 rpm, SatO2 88% ambiental, crépitos bilaterales difusos. Radiografía: infiltrados micronodulares bilaterales difusos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Aciclovir oral 800 mg 5 veces al día y control en 48 horas

B Hospitalizar en UCI, oxígeno y aciclovir endovenoso 10 mg/kg cada 8 horas

C Ceftriaxona más claritromicina endovenosa

D Inmunoglobulina hiperinmune antivaricela intramuscular

E Metilprednisolona endovenosa en pulsos

Respuesta B. Adulto con varicela activa, insuficiencia respiratoria e infiltrados nodulares difusos: neumonitis varicelosa, la complicación más letal (mortalidad > 20–30%). Requiere UCI, oxígeno y aciclovir EV 10 mg/kg cada 8 horas. La vía oral no alcanza niveles terapéuticos a tiempo; la inmunoglobulina sirve como profilaxis post-exposición, no para la enfermedad establecida.

▶ VER CLASE 1.04.2.011 **Enfermedad grave por SARS Cov 2 COVID 19** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.2 · Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín

QUÉ HAY QUE SABER

- COVID-19 grave: disnea, FR >30, saturación <94 % ambiental o infiltrados extensos; crítico si hay SDRA, shock o falla orgánica. Mayor riesgo en adultos mayores, diabéticos, obesos e inmunosuprimidos.
- Confirmación con PCR o antígeno; radiografía o TAC con infiltrados bilaterales periféricos en vidrio esmerilado.
- Con hipoxemia que requiere oxígeno: dexametasona 6 mg/día por hasta 10 días (reduce la mortalidad) más tromboprofilaxis; oxígeno con meta de saturación 92–96 %.
- No usar hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina ni plasma convaleciente de rutina; tocilizumab solo en casos seleccionados por especialista.
- SDRA: ventilación protectora (6 mL/kg de peso ideal, presión plateau ≤30) y prono ≥16 h/día si PaFi <150. Derivar a unidad de paciente crítico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 68 años, diabética, cursa su día 8 de COVID-19. Presenta disnea, FR 30 por minuto y saturación de 88% ambiental. La radiografía muestra infiltrados bilaterales periféricos en vidrio esmerilado. Se inicia oxígeno. **¿Cuál de las siguientes terapias ha demostrado reducir la mortalidad en este contexto?**

A Azitromicina

B Hidroxicloroquina

C Dexametasona 6 mg/día por hasta 10 días

D Ivermectina

E Plasma convaleciente de rutina

Respuesta C. En COVID-19 con hipoxemia que requiere oxígeno o ventilación, la dexametasona 6 mg diarios por hasta 10 días redujo la mortalidad (estudio RECOVERY). Se asocia tromboprofilaxis y, en casos seleccionados, inmunomoduladores como tocilizumab. Hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina y plasma convaleciente de rutina no mostraron beneficio.

Conocimientos generales

13 códigos

▶ VER CLASE 1.04.3.001 **Manejo y prevención de infecciones en personal sanitario**

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 2.1 · Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes

QUÉ HAY QUE SABER

- Precauciones estándar con todo paciente: higiene de manos antes y después de cada contacto, EPP según riesgo y manejo seguro de cortopunzantes (no reencapsular; contenedor rígido cercano).
- Accidente cortopunzante: lavado inmediato con agua y jabón y notificación; ELISA VIH basal del trabajador y controles en día 0, 6 semanas y 3 meses.
- Fuente VIH positiva o desconocida: triterapia profiláctica por 28 días, idealmente en 2–4 h y máximo 72 h, sin esperar la serología de la fuente.
- Contacto con meningococo sin protección (secreciones respiratorias): quimioprofilaxis con rifampicina, ciprofloxacino o ceftriaxona.
- Personal de salud: vacunación contra hepatitis B e influenza anual; N95 en aislamiento aéreo (TBC, sarampión, varicela).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Médica de 30 años sufre accidente cortopunzante con aguja de paciente cuya serología VIH es desconocida. Tras el lavado profuso de la herida, ¿cuál es la conducta más adecuada a seguir? **Seleccione la alternativa correcta:**

A Esperar resultado del ELISA del paciente fuente antes de decidir

B Ofrecer de inmediato triterapia antirretroviral profiláctica (PEP) por 28 días a 6 semanas

C Simplemente observar ya que la fuente probablemente es VIH negativa

D Solicitar PCR para VIH al trabajador de salud de inmediato y esperar resultado

E Iniciar monoterapia con zidovudina por 4 semanas

Respuesta B. Con fuente desconocida o seropositiva, la PEP con triterapia se ofrece de inmediato (idealmente < 2–4 horas, máximo 72 horas) por 28 días. No se posterga esperando la serología de la fuente.

▶ VER CLASE 1.04.3.002 Mordeduras de animales

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.18 · Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica
Infectología 2.2 · Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico

QUÉ HAY QUE SABER

- Aseo profuso con suero a presión: es lo que más reduce la carga bacteriana. Las mordeduras no se suturan de entrada (cierre por segunda intención), salvo en la cara por motivos estéticos, con lavado masivo y antibiótico.
- Gato: colmillos finos que inoculan Pasteurella en profundidad; perro: desgarro y aplastamiento; humana: la más agresiva (Eikenella, anaerobios).
- Amoxicilina-ácido clavulánico es el antibiótico de elección (profiláctico en mano, heridas punzantes, gato, humana o inmunosuprimidos).
- Rabia: perro o gato ubicable, observación del animal por 10 días; no ubicable o vagabundo, vacuna antirrábica inmediata (días 0, 3, 7, 14 y 28); murciélago, vacuna más inmunoglobulina aunque no haya herida visible.
- Profilaxis antitetánica según el esquema previo: la mordedura es herida tetanígena (refuerzo dT si pasaron más de 5 años; dT + IGH-T si tiene menos de 3 dosis).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años es mordido en el dorso de la mano por su perro, que está vacunado y es observable. Consulta 3 horas después con dos heridas punzantes de 0,5 cm, sin compromiso tendíneo. Tiene esquema antitetánico completo, con refuerzo hace 3 años. **Además del aseo profuso de la herida, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Sutura primaria de las heridas y alta sin antibióticos

B Vacunación antirrábica inmediata

C Dejar las heridas abiertas, indicar amoxicilina con ácido clavulánico profiláctica y observar al perro por 10 días

D Cefadroxilo oral y cierre con adhesivo tisular

E Inmunoglobulina antitetánica y vacuna antitetánica

Respuesta C. Las mordeduras en la mano y las heridas punzantes tienen alto riesgo de infección, por lo que no se suturan y se indica amoxicilina con ácido clavulánico, que cubre Pasteurella y anaerobios. Con un perro vacunado y observable no se vacuna contra la rabia: se observa al animal 10 días. Con refuerzo antitetánico hace 3 años no requiere profilaxis.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 28 años despierta en una cabaña de veraneo y encuentra un murciélago vivo volando en su habitación. No presenta heridas evidentes ni recuerda haber sido mordido. **¿Cuál es la conducta inmediata recomendada?**

A Observar al paciente de forma ambulatoria y consultar solo si presenta fiebre o cefalea

B Iniciar vacunación antirrábica completa e inmunoglobulina antirrábica de inmediato

C Capturar al murciélago para observarlo vivo durante 10 días

D Administrar profilaxis con amoxicilina y citar a curaciones diarias

E Descartar el riesgo de rabia dado que no existen lesiones cortantes visibles

Respuesta B. En Chile el murciélago es el reservorio de la rabia y su mordedura puede pasar inadvertida. Despertar con un murciélago en la habitación es exposición grave: vacunación completa inmediata más inmunoglobulina antirrábica.

▶ VER CLASE 1.04.3.003 Prevención de enfermedades de transmisión sexual

DÓNDE SE ENSEÑA

Infectología 3.5 · Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH

QUÉ HAY QUE SABER

- El preservativo usado de forma correcta y consistente en todas las relaciones es la medida más efectiva contra VIH y la mayoría de las ITS; los anticonceptivos hormonales y el DIU no protegen.
- Vacunación contra VPH (PNI escolar) y hepatitis B; tamizaje periódico de VIH y sífilis en personas con conductas de riesgo y en el control prenatal.
- Exposición sexual de riesgo: profilaxis post exposición para VIH con triterapia por 28 días, iniciada lo antes posible y siempre antes de 72 h, más tamizaje de VIH, sífilis y hepatitis B y C.

- PrEP (profilaxis preexposición) para personas con alto riesgo mantenido; I = I: la persona con VIH con carga viral indetectable no transmite por vía sexual.
- Ante toda ITS: buscar las demás, tratar a las parejas sexuales y consejería; reducción del número de parejas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 24 años consulta 24 horas después de una relación sexual sin preservativo con una pareja ocasional de estado VIH desconocido y con conductas de riesgo. Está asintomática. **Además de la anticoncepción de emergencia y el tamizaje de ITS, ¿cuál es la medida preventiva más adecuada?**

A Penicilina benzatina como única medida

B Esperar una serología de VIH a los 6 meses, sin otra medida

C Vacuna contra el VIH

D Profilaxis post exposición (PEP) para VIH, iniciada antes de 72 horas y mantenida por 28 días

E Ninguna medida, por tratarse de una exposición única

Respuesta D. Tras una exposición sexual de riesgo, la profilaxis post exposición con antirretrovirales debe iniciarse lo antes posible, siempre antes de 72 horas, por 28 días. Se complementa con tamizaje de VIH, sífilis y hepatitis B y C, vacuna de hepatitis B si no está inmunizada, consejería en uso de preservativo y PrEP si mantiene conductas de riesgo.

▶ VER CLASE 1.04.3.004 Prevención de enfermedades entéricas

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 2.4 · Intoxicación Alimentaria, Botulismo y Cólera

QUÉ HAY QUE SABER

- Las enfermedades entéricas (diarreas bacterianas y virales, hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera) se transmiten por vía fecal-oral.
- Medida poblacional más efectiva: agua potable y eliminación sanitaria de excretas.
- Medidas individuales: lavado de manos, cocción adecuada de alimentos, lavado de verduras, no consumir mariscos crudos ni lácteos sin pasteurizar, y no recalentar guisos o arroz.
- Vacuna de hepatitis A en el PNI. Los antibióticos profilácticos no están indicados.
- Brotes: notificación a la SEREMI ante la sola sospecha para identificar y cortar la fuente; el cólera es de notificación inmediata.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En una comunidad rural sin red de agua potable se registra un aumento de casos de diarrea aguda y de hepatitis A en niños. **¿Cuál es la medida de prevención más efectiva a nivel poblacional?**

A Antibióticos profilácticos a todos los niños

B Antiparasitarios mensuales a toda la población

C Vacuna BCG

D Suplementación con hierro

E Acceso a agua potable y saneamiento, con lavado de manos e higiene de los alimentos

Respuesta E. Las enfermedades entéricas (diarreas bacterianas y virales, hepatitis A, fiebre tifoidea) se transmiten por vía fecal-oral. Lo más efectivo es el agua potable y la eliminación sanitaria de excretas, junto a lavado de manos, cocción y lavado de alimentos. La vacuna de hepatitis A del PNI refuerza la prevención; los antibióticos profilácticos no están indicados.

▶ VER CLASE 1.04.3.005 Prevención de infecciones hospitalarias

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 2.3 · IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Las IAAS se vigilan, previenen y controlan mediante el comité o programa de IAAS de cada hospital; la higiene de manos es la medida más importante.
- Aislamiento de contacto (bata y guantes): SAMR, BLEE, VRE, C. difficile, rotavirus, sarna. En C. difficile usar agua y jabón: el alcohol no destruye las esporas.
- Gotitas (mascarilla quirúrgica, camas a >1 m): meningococo, influenza, coqueluche, parotiditis, rubéola. Aéreo (N95, pieza individual con presión negativa): TBC bacilífera, sarampión y varicela.
- CVC: técnica aséptica, sin antibiótico profiláctico ni recambio programado; retirar en cuanto no sea necesario.
- Sonda Foley: solo con indicación precisa, sistema cerrado y bolsa bajo la vejiga, retirar lo antes posible; no tratar ni pedir de rutina urocultivos en bacteriuria asintomática del portador de sonda.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

¿Cuál de las siguientes enfermedades infecciosas transmisibles requiere de forma estricta que el paciente sea hospitalizado en una habitación individual con presión negativa y que el personal de salud utilice mascarilla N95? **Seleccione la alternativa correcta:**

A Meningitis aguda por Neisseria meningitidis

B Tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva

C Colitis pseudomembranosa por Clostridioides difficile

D Coqueluche por Bordetella pertussis

E Infección urinaria por Klebsiella pneumoniae productora de BLEE

Respuesta B. La TBC bacilífera se transmite por núcleos de gotitas < 5 micrones que quedan suspendidos en el aire: aislamiento aéreo con N95 y presión negativa. Meningococo y coqueluche usan gotitas (mascarilla quirúrgica); C. difficile y BLEE, contacto.

▶ VER CLASE 1.04.3.006 Prevención de infecciones oportunistas en VIH (+)

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.2 · Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

QUÉ HAY QUE SABER

- La profilaxis primaria depende del recuento de CD4 y se suspende tras la recuperación inmune con TARV.
- CD4 <200 (o <14 %): cotrimoxazol forte 1 comprimido diario contra Pneumocystis; suspender con CD4 >200 por al menos 3 meses.
- CD4 <100 con IgG para Toxoplasma positiva: el mismo cotrimoxazol previene la toxoplasmosis cerebral.
- CD4 <50: azitromicina 1.200 mg semanal contra MAC, hoy solo si no se inicia TARV; suspender con CD4 >100 por 3 meses. PPD ≥5 mm con cualquier CD4: isoniazida 300 mg/día + piridoxina por 9 meses.
- Vacunas: inactivadas indicadas (neumococo, influenza, hepatitis B); vacunas vivas (tres vírica, varicela) contraindicadas con inmunosupresión importante. La mejor prevención es la TARV precoz.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 57

Un lactante de 12 meses, VIH positivo, con cargas virales detectables, en tratamiento antirretroviral acude a control. **¿Qué vacuna está contraindicada en este paciente?**

A Anti meningocócica conjugada

B Anti neumocócica conjugada

C Anti influenza

D Tres vírica

E Anti SARS CoV2

Respuesta D. La tres vírica (sarampión, paperas, rubéola) es la única vacuna a virus vivo atenuado de la lista. En el paciente con VIH se decide según el grado de inmunosupresión, evaluado con los CD4; con carga viral detectable, se contraindica. Las demás son inactivadas o conjugadas y se indican.

▶ VER CLASE 1.04.3.007 Profilaxis de endocarditis infecciosa

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 4.5 · Endocarditis Infecciosa: Criterios de Duke, Tratamiento y Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicada solo en cardiopatías de alto riesgo: prótesis valvular o material protésico de reparación, endocarditis previa, cardiopatías congénitas cianóticas no reparadas o reparadas con defecto residual o en los primeros 6 meses, y trasplante cardíaco con valvulopatía.
- Procedimientos: solo dentales con manipulación de la encía o región periapical o perforación de la mucosa oral; no en endoscopías, procedimientos digestivos o urológicos de rutina.
- Esquema: amoxicilina 2 g oral (niños 50 mg/kg) 30–60 minutos antes del procedimiento.
- Alergia a penicilina: clindamicina 600 mg oral (o azitromicina o claritromicina 500 mg); sin vía oral, ampicilina o cefazolina EV.
- No requieren profilaxis: valvulopatías nativas sin endocarditis previa, prolapso mitral, soplos funcionales ni CIA aislada. La higiene oral y el control dental periódico son la medida preventiva más importante.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 60 años, portador de una prótesis valvular aórtica mecánica, debe someterse a una extracción dental. No tiene alergias. **¿Cuál es la profilaxis de endocarditis infecciosa más adecuada?**

A No requiere profilaxis

B Ciprofloxacino oral

C Amoxicilina 500 mg cada 8 horas por 7 días después del procedimiento

D Amoxicilina 2 g oral, 30 a 60 minutos antes del procedimiento

E Vancomicina endovenosa por 5 días

Respuesta D. La profilaxis está indicada en pacientes de alto riesgo (prótesis valvular, endocarditis previa, ciertas cardiopatías congénitas) sometidos a procedimientos dentales con manipulación gingival o periapical. Se usa una dosis única de amoxicilina 2 g oral, 30 a 60 minutos antes; en alérgicos, un macrólido. No se recomiendan cursos prolongados posteriores.

▶ VER CLASE 1.04.3.008 Profilaxis de tétanos

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 2.2 · Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico

QUÉ HAY QUE SABER

- Primero el aseo de la herida; luego dos preguntas: ¿qué herida es (limpia o sucia/tetanígena) y cuántas dosis tiene?
- Esquema completo (≥3 dosis): herida limpia, refuerzo dT si pasaron más de 10 años; herida sucia, refuerzo dT si pasaron más de 5 años.
- Menos de 3 dosis o desconocido: completar esquema dT (3 dosis); si la herida es sucia, agregar inmunoglobulina antitetánica 250 UI IM.
- La vacuna y la inmunoglobulina se administran en sitios anatómicos separados.
- Heridas tetanígenas: punzantes, con tierra o heces, tejido desvitalizado, quemaduras, fracturas expuestas y mordeduras.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 32 años, campesino, sufre una herida punzante profunda en la planta del pie derecho con un clavo oxidado en un establo. Recibió sus vacunas en la infancia, pero no recuerda ningún refuerzo en los últimos 15 años. Examen: herida puntiforme de 1 cm, márgenes desvitalizados y restos de barro. **Además del aseo de la herida, ¿cuál es la conducta antitetánica más adecuada?**

A Refuerzo con vacuna dT, sin inmunoglobulina

B Vacuna dT + inmunoglobulina antitetánica 250 UI

C Solo inmunoglobulina antitetánica 250 UI

D No requiere profilaxis por su vacunación infantil

E Inmunoglobulina antitetánica 3.000 UI y metronidazol EV

Respuesta A. Herida tetanígena (punzante, con barro y tejido desvitalizado) en un paciente con esquema completo en la infancia (≥ 3 dosis) y último refuerzo hace más de 10 años: refuerzo con dT. La IGH-T se reserva para herida sucia con esquema incompleto o desconocido.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 45 años consulta tras cortarse la mano con una lata oxidada en su patio. Su esquema de vacunación contra el tétanos está al día, habiendo recibido su última dosis de refuerzo hace 3 años. **¿Cuál es la indicación correcta?**

A Aseo quirúrgico local de la herida sin necesidad de vacuna ni inmunoglobulina

B Administrar refuerzo con toxoide tetánico (dT)

C Administrar inmunoglobulina antitetánica (IGH-T) en dosis de 250 UI

D Administrar vacuna dT + inmunoglobulina antitetánica

E Iniciar profilaxis antibiótica con ciprofloxacino por 10 días

Respuesta A. Esquema completo con última dosis hace menos de 5 años: la protección es suficiente incluso ante una herida sucia. Solo se requiere aseo prolijo de la herida.

▶ VER CLASE 1.04.3.009 Profilaxis de tuberculosis

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 2.1 · Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes
Respiratorio 2.5 · Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Ante todo contacto de un caso bacilífero, primero descartar TBC activa con síntomas, radiografía de tórax y baciloscopías; si está enfermo, se trata con el esquema completo.
- Contactos menores de 15 años o con VIH: isoniazida 10 mg/kg/día (máximo 300 mg) de entrada, sin esperar el PPD; se repite el PPD al tercer mes: si es negativo se suspende y si vira se completan 6 meses.
- Adultos: terapia preventiva si el PPD es ≥10 mm (≥5 mm en VIH o inmunosuprimidos) y se descartó enfermedad activa; 6 meses (9 meses en VIH); el embarazo no la contraindica.
- Recién nacido de madre bacilífera: isoniazida por 6 meses, BCG al terminar la quimioprofilaxis y lactancia materna con mascarilla quirúrgica materna.

- Antes de terapia biológica o corticoides prolongados, tamizaje de TBC latente (PPD o IGRA); agregar piridoxina en diabéticos, desnutridos, alcohólicos, embarazadas y VIH.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 142

¿Cuál es la conducta más adecuada para un paciente, que es contacto intradomiciliario de otro individuo diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera?
Seleccione la alternativa correcta:

A Solicitar PPD y cultivo de expectoración
B Solicitar radiografía de tórax y baciloscopías
C Controlar clínicamente por 3 meses
D Indicar profilaxis con isoniazida por 6 meses
E Solicitar cultivo de Koch y broncoscopía

Respuesta B. El primer paso con todo contacto es descartar tuberculosis activa: síntomas, radiografía de tórax y baciloscopías. Recién después se decide la profilaxis (de entrada en menores de 15 años; según PPD en adultos).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 16

Una paciente de 30 años, asintomática, está cursando un embarazo de 20 semanas. Su marido fue recientemente diagnosticado de tuberculosis pulmonar, mediante baciloscopías de expetoración que resultaron (+++). La mujer se realiza baciloscopías, que son negativas y un PPD que resulta 26 mm. **¿Cuál es la conducta más adecuada para con ella?**

A Mantener una conducta expectante como protección fetal
B Iniciar tratamiento con 4 fármacos (isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol).
C Repetir las baciloscopías periódicamente
D Administrar la vacuna BCG
E Indicar profilaxis con isoniazida por 6 meses

Respuesta E. Adulta asintomática, con baciloscopías negativas (sin TBC activa) y PPD > 10 mm tras contacto bacilífero: profilaxis con isoniazida por 6 meses. El embarazo no la contraindica.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de término, sano, de 2 días de vida. A su madre se le diagnostica tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva durante la hospitalización del puerperio. El niño está asintomático, con examen físico normal. Aún no ha recibido la vacuna BCG. **¿Cuál es la conducta más adecuada con el recién nacido?**

A Vacunar con BCG hoy y suspender la lactancia materna
B Isoniazida por 6 meses, postergar la BCG y mantener la lactancia con mascarilla materna
C Isoniazida por 6 meses junto con la BCG hoy
D Solicitar PPD y decidir la isoniazida según el resultado
E Separar al niño de la madre hasta que ella negativice la baciloscopía

Respuesta B. Hijo de madre con TBC activa bacilífera: tres medidas simultáneas. Isoniazida por 6 meses, BCG al término de la quimioprofilaxis (la isoniazida neutraliza el bacilo vacunal) y lactancia materna con mascarilla quirúrgica materna.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 81

Una paciente de 39 años, inmigrante, VIH positiva sin tratamiento desde hace 2 años, consulta por síntomas respiratorios, que comenzaron hace 3 semanas, consistentes en tos con expectoración mucopurulenta, fiebre y malestar general. Ha utilizado amoxicilina automedicada, sin respuesta. Al examen físico está enflaquecida. El examen pulmonar se auscultan estertores y crépitos en el lóbulo superior derecho. Se solicita PPD, que resulta 5 mm; baciloscopías de expectoración, que resultan negativas; y se toma cultivo líquido MGIT, que resultó positivo a los 15 días. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: Radio): ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Iniciar tratamiento profiláctico para la tuberculosis
B Iniciar tratamiento estándar para la tuberculosis
C Esperar el resultado del cultivo estándar para mycobacterias
D Reiniciar la triterapia antirretroviral
E Solicitar PCR para Mycobacterium tuberculosis

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Iniciar tratamiento profiláctico para la tuberculosis (opción A).

▶ VER CLASE 1.04.3.010 Profilaxis en contactos de infecciones meningocócicas

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 2.1 · Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes

QUÉ HAY QUE SABER

- La enfermedad meningocócica es de notificación inmediata para identificar a los contactos y darles quimioprofilaxis a tiempo, idealmente antes de 24 h.
- Contactos que la reciben: convivientes y quienes pernoctaron bajo el mismo techo en los últimos 7 días, contactos de sala cuna o jardín infantil y personal de salud expuesto a secreciones sin protección. Los compañeros de curso escolar no la requieren de rutina.
- Rifampicina 600 mg c/12 h por 2 días (niños 10 mg/kg c/12 h).

- Alternativas: ciprofloxacino 500 mg VO dosis única en adultos; ceftriaxona 250 mg IM dosis única, de elección en embarazadas.
- No se espera a que el contacto tenga fiebre; la profilaxis busca erradicar la portación.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Escolar de 9 años es hospitalizado por meningococcemia. Vive con sus padres y un hermano de 6 años. Una compañera de curso se sentó a su lado en clases, sin contacto con sus secreciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la quimioprofilaxis?**

A Indicarla a todo el colegio con amoxicilina

B Indicarla a los contactos intradomiciliarios, idealmente en las primeras 24 horas, con rifampicina, ciprofloxacino o ceftriaxona

C Indicarla solo al personal de salud que lo atendió

D Indicarla a los contactos solo si presentan fiebre

E No indicarla, porque basta con vacunar

Respuesta B. La quimioprofilaxis se indica a contactos íntimos: convivientes, contactos de sala cuna o jardín infantil y personal de salud expuesto a secreciones sin protección, idealmente antes de 24 horas. Se usa rifampicina por 2 días, ciprofloxacino en dosis única en adultos o ceftriaxona en dosis única. Los compañeros de curso escolares no la requieren de rutina.

▶ VER CLASE 1.04.3.011 Uso y abuso de antibióticos

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 2.3 · IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Usar antibióticos solo con indicación precisa, en dosis y duración adecuadas; el abuso selecciona resistencia (SAMR, BLEE) y favorece la infección por C. difficile.
- No tratar la bacteriuria asintomática salvo en embarazadas y antes de procedimientos urológicos con sangrado de mucosa; tampoco en portadores de sonda.
- No dar antibióticos en cuadros virales ni en intoxicaciones alimentarias por toxina preformada; no usar antibiótico profiláctico en CVC.
- Antes de iniciar antibióticos en infecciones graves, tomar cultivos (sin retrasar el tratamiento) y luego ajustar al antibiograma (desescalar).
- Nunca agregar un solo fármaco a un esquema que está fallando (por ejemplo en TBC): genera más resistencia.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 120

Un paciente incia tratamiento antituberculoso con 4 fármacos, por una tuberculosis pulmonar. Al séptimo día de tratamiento presenta vómitos y dolor abdominal luego de recibir los fármacos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Agregar omeprazol al tratamiento

B Retirar uno de los 4 fármacos

C Suspender el tratamiento y solicitar pruebas hepáticas

D Derivar para tratamiento secundario

E Mantener el tratamiento

Respuesta C. Vómitos y dolor abdominal tras los fármacos obligan a sospechar hepatotoxicidad, la reacción adversa más frecuente del esquema (isoniazida, rifampicina y sobre todo pirazinamida). Se suspende y se confirma con pruebas hepáticas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 38

Una paciente de 33 años, sin antecedentes, cursa con cuadro de dolor lumbar y fiebre desde hace un día, asociado a disuria y orinas de mal olor. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, con temperatura de 38°C y en el resto del examen solo destaca puño percusión positiva a derecha. Se solicita sedimento de orina y urocultivo, con lo que se confirma pielonefritis aguda por lo que inicia tratamiento ambulatorio con ciprofloxacino. Dos días después acude a control persistiendo sintomática. Su resultado del urocultivo muestra presencia de echericha coli sensible a nitrofurantoina, carbapenémicos, ampicilina/sulbactam y amikacina, y resistente a cefalosporinas, gentamicina y ciprofloxacino. **¿Cuál de los siguientes fármacos es el de elección para el manejo en este caso?**

A Amikacina

B Nitrofurantoina

C Ertapenem

D Ampicilina

E Moxifloxacino

Respuesta C. Una E. coli resistente a cefalosporinas es una BLEE: el tratamiento de elección es un carbapenémico (ertapenem 1 g al día). La nitrofurantoína no alcanza el parénquima renal y el moxifloxacino comparte la resistencia a quinolonas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 33

Adulto mayor de 78 años con sonda Foley permanente. Un urocultivo de rutina informa E. coli >100.000 UFC/mL. El paciente está asintomático y afebril. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A No tratar: la bacteriuria asintomática en portador de sonda no requiere antibióticos

B Iniciar nitrofurantoína por 7 días

C Iniciar ciprofloxacino por 7 días

D Cambiar la sonda y tratar con cefazolina

E Repetir el urocultivo en 48 horas

Respuesta A. Casi todos los portadores de sonda permanente tienen bacteriuria. Sin síntomas no se trata: el antibiótico no da beneficio, selecciona resistencia y favorece C. difficile; tampoco deben pedirse urocultivos de rutina. La bacteriuria asintomática solo se trata en embarazadas y antes de procedimientos urológicos con sangrado de mucosa.

▶ VER CLASE 1.04.3.012 Vacunas especiales (neumococo, influenza, hepatitis A y B, varicela, rabia, meningococo)

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 2.2 · Rabia y Tétanos: Profilaxis de Heridas y Manejo Clínico

QUÉ HAY QUE SABER

- Esplenectomía: vacunar contra neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae b al menos 2 semanas antes de la cirugía programada (o 2 semanas después si fue de urgencia), más influenza anual.
- Influenza: anual a mayores de 60 años, embarazadas, enfermos crónicos, niños pequeños y personal de salud. Neumococo: adultos mayores y enfermos crónicos o inmunosuprimidos.
- Hepatitis B en personal de salud y grupos de riesgo; hepatitis A en el PNI y en riesgo de exposición.
- Rabia: mordedura de perro o gato no ubicable, vacuna de 5 dosis (días 0, 3, 7, 14 y 28); contacto con murciélago, vacuna más inmunoglobulina antirrábica, aunque no haya herida visible. Animal ubicable: observación veterinaria por 10 días.
- Vacunas vivas (varicela, tres vírica, fiebre amarilla) contraindicadas en embarazo e inmunosupresión importante; las inactivadas y conjugadas sí se indican.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 40 años será sometido a una esplenectomía electiva por un púrpura trombocitopénico inmune refractario a tratamiento médico. **¿Qué vacunas se deben indicar, idealmente al menos 2 semanas antes de la cirugía?**

A Solo la vacuna contra la influenza

B BCG y fiebre amarilla

C Neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae tipo b

D Rabia y hepatitis A

E Ninguna; se vacuna solo si presenta infecciones después de la cirugía

Respuesta C. El asplénico tiene riesgo de sepsis fulminante por bacterias capsuladas: neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae tipo b. Se vacuna al menos 2 semanas antes de la esplenectomía programada, o 2 semanas después si fue de urgencia, y se agrega influenza anual. Las vacunas vivas como la BCG no tienen indicación aquí.

▶ VER CLASE 1.04.3.013 Vacunas incluidas en el PNI (Plan Nacional de Inmunizaciones)

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.3 · Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026

QUÉ HAY QUE SABER

- Calendario PNI: recién nacido BCG y hepatitis B; 2, 4 y 6 meses hexavalente (más neumocócica conjugada a los 2 y 4 meses); 12 meses tres vírica, meningocócica y refuerzo neumocócico; 18 meses hexavalente, hepatitis A y varicela.
- Vivas atenuadas (BCG, tres vírica, varicela): contraindicadas en embarazo e inmunosupresión grave (corticoides en dosis alta); las inactivadas o conjugadas son seguras.
- Falsas contraindicaciones: resfrío o fiebre baja, antibióticos en curso, alergia al huevo (no contraindica tres vírica ni influenza) y prematurez (se vacuna por edad cronológica; la BCG espera los 2.000 g).
- Embarazada: influenza inactivada en campaña y dTpa desde la semana 28; la tres vírica se posterga al posparto.
- Además: nirsevimab (anticuerpo, no vacuna) contra VRS en menores de 6 meses, VPH en escolares, influenza anual a grupos de riesgo y neumocócica polisacárida en adultos mayores.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 26 años, con 12 semanas de embarazo, consulta por su calendario de vacunas. No recuerda haber recibido la vacuna contra el sarampión. **¿Cuál de las siguientes vacunas del PNI es de virus vivos atenuados y está contraindicada durante el embarazo?**

A Tres vírica (sarampión, rubéola y parotiditis)

B dTpa

C Influenza inactivada

D Hepatitis B

E Neumocócica conjugada

Respuesta A. La tres vírica es de virus vivos atenuados y está contraindicada en el embarazo; se administra en el postparto. En la gestante, el PNI indica influenza inactivada en campaña y dTpa desde la semana 28, para proteger al recién nacido de la tos convulsiva. Las vacunas inactivadas son seguras en el embarazo.

Exámenes e imagenología

16 códigos

▶ VER CLASE 1.04.4.001 **Antigenemia** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.2 · Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

QUÉ HAY QUE SABER

- Antigenemia pp65 de CMV: detecta antígeno viral en leucocitos de sangre periférica y cuantifica la replicación activa; hoy se reemplaza progresivamente por la PCR cuantitativa (carga viral) de CMV.
- Indicaciones: trasplantados de órgano sólido o médula, VIH avanzado (CD4 <50) y otros inmunosuprimidos con fiebre, citopenias, hepatitis, neumonitis, colitis o retinitis sugerentes de CMV.
- Interpretación: resultado positivo indica infección activa (replicación); recuentos altos o en ascenso se asocian a enfermedad y orientan a tratamiento con ganciclovir o valganciclovir; recuentos seriados sirven para monitorizar la respuesta.
- Se usa en estrategia anticipada (pre-emptive): monitorización periódica post trasplante e inicio de tratamiento antes de que aparezca la enfermedad.
- Limitaciones: requiere procesar la muestra en pocas horas y no es útil con neutropenia profunda (pocos leucocitos); la serología IgG positiva solo indica infección pasada y no sirve para este fin.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 50 años, con trasplante renal hace 2 meses y en tratamiento inmunosupresor, presenta fiebre, leucopenia, alza de transaminasas y deterioro de la función renal. **¿Cuál es el examen más útil para confirmar precozmente la sospecha diagnóstica?**

A Serología IgG para citomegalovirus

B Hemocultivos aeróbicos

C Antigenemia pp65 o carga viral (PCR) de citomegalovirus en sangre

D Gota gruesa

E Test de tinta china

Respuesta C. El citomegalovirus es la infección oportunista más frecuente entre el primer y sexto mes post trasplante: fiebre, leucopenia, hepatitis y disfunción del injerto. Se diagnostica con antigenemia pp65 (antígeno viral en leucocitos) o PCR cuantitativa en sangre, que también guían la terapia con ganciclovir. La IgG solo indica infección pasada.

▶ VER CLASE 1.04.4.002 **Cultivo de heridas o abscesos** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.17 · Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: abscesos, infecciones de herida operatoria, pie diabético o mordeduras infectadas, sobre todo si hay riesgo de gérmenes resistentes o falla del tratamiento empírico.
- Toma correcta: limpiar la superficie con suero y obtener aspirado de pus o biopsia de tejido profundo; las tórulas superficiales y los apósitos se contaminan con flora colonizante y dan resultados poco confiables.
- Enviar rápido al laboratorio, idealmente antes de iniciar antibióticos; solicitar cultivo para anaerobios si la muestra es profunda o con olor fétido.
- Interpretación: el Gram orienta la terapia inicial (cocos Gram positivos en racimos: estafilococo); el antibiograma permite ajustar, por ejemplo vancomicina si es SAMR (resistente a oxacilina).
- Flora cutánea habitual en una tórula superficial suele ser contaminación; el tratamiento base del absceso sigue siendo el drenaje.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 62 años, diabética, presenta al 6° día postoperatorio una herida abdominal con eritema, induración y salida de pus. Se abre la herida y se drena. **¿Cuál es la forma más adecuada de obtener una muestra para cultivo?**

A Tórula superficial de la piel alrededor de la herida

B No tomar cultivos en infecciones de herida

C Cultivo de la gasa del apósito

D Hemocultivos solamente

E Aspirado de pus o biopsia de tejido profundo, tras limpiar la superficie

Respuesta E. El cultivo de heridas y abscesos se toma por aspiración del pus o biopsia de tejido profundo, previa limpieza de la superficie con suero, para evitar la flora colonizante de la piel. Las tórulas superficiales y los apósitos dan resultados poco confiables. La muestra se envía rápido al laboratorio, idealmente antes de iniciar antibióticos.

▶ VER CLASE 1.04.4.003 Cultivos de hongos

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.16 · Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: confirmar onicomicosis, tiñas extensas o de cuero cabelludo y lesiones dudosas antes de un tratamiento oral prolongado; hasta la mitad de las distrofias ungueales no son micóticas (psoriasis, trauma, liquen).
- Examen micológico directo con KOH: resultado rápido, muestra hifas o levaduras; el cultivo (Sabouraud) tarda semanas pero identifica el agente (dermatofito, levadura o moho) y orienta el fármaco.
- Toma: raspado del borde activo de la lesión o del lecho ungueal distal, sin antimicóticos tópicos las semanas previas.
- Interpretación: dermatofito confirma tiña u onicomicosis tratable con terbinafina (12 semanas en uñas de pies); Candida orienta a azoles; un cultivo negativo con KOH positivo no descarta.
- Un resultado negativo con clínica dudosa obliga a reconsiderar el diagnóstico antes de exponer al paciente al costo y riesgo hepático del tratamiento sistémico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 55 años consulta por engrosamiento, color amarillento y desprendimiento distal de las uñas de ambos ortejos mayores, de 2 años de evolución. Desea tratamiento oral. **¿Cuál es la conducta más adecuada antes de iniciar terbinafina oral?**

A Iniciar terbinafina sin estudio

B Confirmar con examen micológico directo (KOH) y cultivo de hongos de la uña

C Biopsia de la matriz ungueal en todos los casos

D Radiografía del ortejo

E Hemocultivos

Respuesta B. Hasta la mitad de las distrofias ungueales no son micóticas (psoriasis, trauma, liquen). Antes de un tratamiento oral prolongado (terbinafina por 12 semanas en pies), con costo y riesgo hepático, se confirma la onicomicosis con examen directo con KOH y cultivo micológico, que además identifica el agente: dermatofito, levadura o moho.

▶ VER CLASE 1.04.4.004 Detección de antígeno de Cryptococcus en LCR y test de tinta china

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.2 · Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: meningitis subaguda en VIH avanzado (CD4 <100) con cefalea progresiva, fiebre baja, vómitos y escasa o nula rigidez de nuca.
- LCR típico: presión de apertura muy elevada (>30 cm H2O), pocas células linfocitarias, glucosa baja y proteínas levemente altas.
- Antígeno criptocócico (CrAg) en LCR o sangre: sensibilidad y especificidad >95 %; es el examen de elección para confirmar.
- Tinta china: levaduras con halo (cápsula); clásica pero menos sensible (alrededor de 70–80 %), un resultado negativo no descarta.
- Positivo: inducción con anfotericina B liposomal + flucitosina por 2 semanas, luego fluconazol, y punciones evacuadoras si la presión está alta; derivar.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 38 años con VIH sin tratamiento y CD4 de 40 células/mm³ presenta cefalea progresiva de 2 semanas, fiebre baja y vómitos, sin signos focales. La TAC de encéfalo es normal. La punción lumbar muestra presión de apertura de 35 cmH2O, 20 células/mm³ de predominio linfocitario, glucosa baja y proteínas levemente elevadas. **¿Cuál es el examen más sensible y específico para confirmar el diagnóstico más probable?**

A Antígeno de Cryptococcus en LCR

B Tinta china en LCR

C Gram de LCR

D ADA en LCR

E Cultivo de Koch

Respuesta A. Meningitis subaguda con hipertensión intracraneana en VIH con CD4 bajo 100 sugiere criptococosis. El antígeno criptocócico en LCR (o suero) tiene sensibilidad y especificidad sobre 95%, superior a la tinta china (sensibilidad cercana a 70-80%). Se trata con anfotericina B más flucitosina y punciones evacuadoras si la presión está elevada.

▶ VER CLASE 1.04.4.005 Detección de agentes virales por inmunofluorescencia

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.5 · Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Inmunofluorescencia de aspirado o hisopado nasofaríngeo: identifica en horas VRS, influenza A y B, adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus.
- Utilidad principal en hospitalizados: aislar y cohortar pacientes, aplicar precauciones de contacto o gotitas y vigilancia epidemiológica; si muestra influenza, orienta a oseltamivir.
- La bronquiolitis y otras infecciones respiratorias virales son diagnóstico clínico: el examen no define gravedad ni justifica antibióticos o corticoides.
- Es menos sensible que la PCR (panel molecular); un resultado negativo con clínica sugerente no descarta la infección.
- Requiere una buena muestra con células epiteliales, tomada en los primeros días de síntomas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 4 meses es hospitalizado en julio por bronquiolitis con requerimiento de oxígeno. Se solicita panel viral por inmunofluorescencia en aspirado nasofaríngeo. **¿Cuál es la principal utilidad de este examen en este paciente?**

A Decidir el uso de antibióticos de rutina

B Identificar el virus (VRS, influenza, adenovirus, parainfluenza, metapneumovirus) para aislar y cohortar pacientes, y para vigilancia epidemiológica

C Confirmar el diagnóstico de bronquiolitis, que no puede hacerse sin él

D Indicar corticoides

E Evaluar la gravedad del cuadro

Respuesta B. La bronquiolitis es un diagnóstico clínico. En hospitalizados, la inmunofluorescencia del aspirado nasofaríngeo identifica el virus en horas, lo que permite cohortar pacientes, aplicar precauciones de contacto o gotitas y hacer vigilancia epidemiológica; si muestra influenza, orienta a oseltamivir. No define la gravedad ni justifica antibióticos o corticoides.

▶ VER CLASE 1.04.4.006 Estudio citoquímico de LCR

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.2 · Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

QUÉ HAY QUE SABER

- Valores normales: presión de apertura 10–20 cm H2O, <5 leucocitos/mm³, glucosa LCR/suero >0,6 y proteínas <45 mg/dL.
- Bacteriana: presión >25, 1.000–10.000 leucocitos con >80 % PMN, glucosa <0,4 y proteínas 100–500 mg/dL.
- Viral (aséptica): 50–500 células mononucleares, glucosa normal y proteínas 50–100 mg/dL; el agente más frecuente es enterovirus.
- Tuberculosa o fúngica: presión >30, 100–500 linfocitos, glucosa muy baja (<0,3) y proteínas muy altas. Encefalitis herpética: patrón viral con eritrocitos o xantocromía.
- La glucosa es el dato que más discrimina; interpretar siempre con la glicemia simultánea y completar con Gram, cultivo, PCR o antígenos según la sospecha.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años con 5 días de cefalea, fiebre de 38 °C y rigidez de nuca, sin compromiso de conciencia ni focalidad. LCR: claro, 180 células/mm³ con 90 % de linfocitos, proteínas 0,7 g/L, glucosa 60 mg/dL con glicemia de 100 mg/dL, y Gram sin bacterias. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Enterovirus

B Streptococcus pneumoniae

C Mycobacterium tuberculosis

D Listeria monocytogenes

E Neisseria meningitidis

Respuesta A. LCR claro con pleocitosis linfocitaria moderada, proteínas levemente elevadas y glucosa normal (índice LCR/plasma 0,6) es un patrón de meningitis viral, y el agente más frecuente es enterovirus. La bacteriana da neutrófilos y glucosa baja; la tuberculosa, linfocitos con glucosa muy baja y proteínas muy altas.

▶ VER CLASE 1.04.4.007 Cultivo de expectoración

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 2.5 · Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: neumonía grave u hospitalizada, mala respuesta al tratamiento, sospecha de gérmenes resistentes, bronquiectasias o fibrosis quística, y estudio de TBC (baciloscopía y cultivo de Koch).
- Calidad de la muestra: expectoración profunda (no saliva), con >25 leucocitos y <10 células epiteliales por campo; el Gram valida la muestra y orienta (diplococos Gram positivos lanceolados: neumococo; cocos en racimos: estafilococo).
- Enviar rápido al laboratorio, idealmente antes del antibiótico. Su rendimiento es bajo en la neumonía comunitaria ambulatoria, donde no se pide de rutina.
- TBC: 2 muestras (una inmediata y otra matinal al día siguiente) para baciloscopía, GeneXpert y cultivo de Koch (Löwenstein-Jensen o MGIT), que es el estándar de oro y el único que da antibiograma completo.
- Interpretar en contexto: flora orofaríngea mixta suele ser contaminación; un cultivo de Koch positivo confirma TBC activa aunque la baciloscopía sea negativa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 17

Un paciente presenta 2 meses de malestar general, tos con expectoración, sensación febril, baja de peso y sudoración. En el último tiempo ha aumentado la tos y ha presentado expectoración hemoptoica. El hemograma muestra leucocitosis de 15.000/mm³ y la radiografía de tórax AP muestra compromiso de ambos lóbulos superiores, mayor al lado izquierdo, con una banda atelectásica en el ápice izquierdo. **¿Cuál es el examen más adecuado ante la sospecha diagnóstica?**

A Broncoscopía

B Baciloscopías de expectoración más cultivo de Koch

C TAC de tórax

D Cultivo de expectoración

E Hemocultivos

Respuesta B. Tos productiva prolongada, baja de peso, sudoración, hemoptisis y compromiso de lóbulos superiores sugieren tuberculosis pulmonar. Se estudia en expectoración con baciloscopías (o PCR para TBC, cada vez más usada como examen inicial) más cultivo de Koch. El cultivo corriente de expectoración no detecta Mycobacterium tuberculosis.

▶ VER CLASE 1.04.4.008 Gram

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 2.3 · Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa

QUÉ HAY QUE SABER

- El Gram clasifica bacterias según su pared y forma en minutos; orienta la terapia empírica antes del cultivo.
- Cocos Gram positivos en racimos: estafilococos (S. aureus); en cadenas: estreptococos; diplococos lanceolados: neumococo; en pares o cadenas cortas: enterococo.
- Diplococos Gram negativos: Neisseria (intracelulares en PMN en uretritis = gonococo; en LCR = meningococo). Bacilos Gram positivos: Listeria, Clostridium, B. anthracis (caña de bambú). Bacilos Gram negativos: enterobacterias, Pseudomonas, Haemophilus.
- Ver PMN sin bacterias orienta a gérmenes que no se tiñen (Chlamydia, Mycoplasma, Legionella) o a tratamiento antibiótico previo; las micobacterias requieren Ziehl-Neelsen.
- En expectoración la muestra es válida si tiene >25 PMN y <10 células epiteliales por campo de menor aumento.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 135

En el examen microscópico de una muestra de esputo se observan cocos grampositivos agrupados en racimos. **¿A qué bacteria corresponde este patrón morfológico?**

A Staphylococcus aureus
B Streptococcus pneumoniae
C Enterococcus faecalis
D Listeria monocytogenes
E Neisseria meningitidis

Respuesta A. Los cocos grampositivos en racimos corresponden a estafilococos, como S. aureus, causa de neumonía post influenza, nosocomial y necrotizante. S. pneumoniae se ve como diplococos grampositivos lanceolados, Enterococcus en pares o cadenas cortas, Listeria como bacilos grampositivos y Neisseria como diplococos gramnegativos.

▶ VER CLASE 1.04.4.009 Hemocultivo

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.1 · Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: fiebre con sospecha de bacteriemia, sepsis, endocarditis, infección de catéter, meningitis o neumonía grave.
- Técnica: al menos 2 sets por punciones de sitios distintos, antes del antibiótico pero sin retrasarlo (en shock séptico, dentro de la primera hora); no es necesario esperar el peak febril.
- Un solo set dificulta distinguir contaminantes; S. epidermidis en un solo frasco suele ser contaminación, mientras S. aureus siempre es significativo.
- Sospecha de infección de catéter: hemocultivos pareados (periférico y de cada lumen); el CVC positivo >2 h antes que el periférico apunta al catéter.
- S. aureus o Candida en hemocultivos obligan a buscar foco y complicaciones: ecocardiograma (endocarditis) y fondo de ojo (endoftalmitis por Candida).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 70 años llega a urgencia con fiebre de 39 °C, confusión, PA 85/50 mmHg, FC 120 por minuto y lactato de 4 mmol/L. Se sospecha shock séptico de foco urinario. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de los hemocultivos?**

A Iniciar antibióticos y tomar hemocultivos al día siguiente si persiste la fiebre
B Esperar el peak febril para tomar los hemocultivos
C Tomar 1 solo hemocultivo para ahorrar recursos
D Tomar 2 sets de hemocultivos de sitios distintos antes del antibiótico, sin retrasar su inicio más allá de la primera hora
E Tomar los hemocultivos desde la sonda urinaria

Respuesta D. En sepsis se toman al menos 2 sets de hemocultivos por punciones separadas antes del antibiótico, pero sin retrasarlo: en shock séptico debe darse dentro de la primera hora. No es necesario esperar el peak febril, y tomarlos tras el antibiótico reduce su rendimiento. Un solo set dificulta distinguir contaminantes.

▶ VER CLASE 1.04.4.010 Hemograma y velocidad de hemosedimentación (VHS)

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.2 · Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH

QUÉ HAY QUE SABER

- Leucocitosis con neutrofilia y desviación izquierda orienta a infección bacteriana; la leucopenia con neutropenia aparece en tifoidea (hemograma tífico, con aneosinofilia), virosis, sepsis grave o quimioterapia.
- Linfocitosis con más de 10 % de linfocitos atípicos: mononucleosis por VEB (también CMV, toxoplasma, VIH agudo). Eosinofilia marcada: parasitosis tisulares (triquinosis), alergia o fármacos.
- Neutropenia febril: calcular el RAN = leucocitos × (% segmentados + % baciliformes)/100; <500 define riesgo. Hanta: plaquetas <100.000, hematocrito alto e inmunoblastos >10 %.
- VHS: marcador inespecífico de inflamación, sube lento y baja lento; muy alta (>100 mm/h) en osteomielitis, endocarditis, TBC, arteritis de células gigantes, mieloma o neoplasias; útil en el seguimiento de osteomielitis.
- Ninguno de los dos es diagnóstico por sí solo: interpretarlos con la clínica y repetir para evaluar la evolución.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un estudiante de 18 años presenta, desde hace 1 semana, fiebre, odinofagia intensa con exudado amigdalino, adenopatías cervicales posteriores y esplenomegalia leve. **¿Qué hallazgo del hemograma es más característico del diagnóstico más probable?**

A Neutrofilia con desviación a izquierda

B Policitemia

C Eosinofilia marcada

D Pancitopenia con blastos

E Linfocitosis con más de 10% de linfocitos atípicos (reactivos)

Respuesta E. Fiebre, faringitis exudativa, adenopatías cervicales posteriores y esplenomegalia en un adolescente sugieren mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr. El hemograma muestra linfocitosis con más de 10% de linfocitos atípicos y suele haber alza leve de transaminasas. Se confirma con anticuerpos heterófilos o IgM anti-VCA. La neutrofilia orientaría a infección bacteriana.

▶ VER CLASE 1.04.4.011 Parasitológico de deposiciones

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.1 · Diarrea Aguda y Crónica en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: diarrea prolongada o crónica, esteatorrea, dolor abdominal recurrente, eosinofilia o contactos con parasitosis; no se pide en la diarrea aguda habitual.
- Técnica: parasitológico seriado con 3 muestras en días distintos en frasco con fijador, porque la eliminación de quistes y huevos es intermitente.
- Hallazgos frecuentes: quistes de Giardia lamblia (tratar con tinidazol o metronidazol), Blastocystis, Entamoeba histolytica, huevos de Trichuris o Ascaris.
- El test de Graham (cinta adhesiva perianal matinal) es el examen para Enterobius vermicularis ante prurito anal; el parasitológico habitual no lo detecta.
- En inmunosuprimidos (VIH con CD4 <100) pedir tinción de Ziehl-Neelsen modificada para Cryptosporidium, Cystoisospora y Cyclospora, que no se ven en el examen habitual.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 5 años, que asiste a jardín infantil, presenta deposiciones blandas, malolientes y esteatorreicas, distensión abdominal y baja de peso de 6 semanas de evolución. **¿Cuál es el examen más adecuado para el diagnóstico etiológico más probable?**

A Coprocultivo

B Test de Graham

C Examen parasitológico seriado de deposiciones (3 muestras en días distintos)

D Colonoscopía

E Antígeno de rotavirus en deposiciones

Respuesta C. Diarrea crónica esteatorreica con distensión y baja de peso en un preescolar de jardín infantil sugiere giardiasis. El parasitológico seriado (3 muestras en días alternos, con fijador) mejora la sensibilidad porque la eliminación de quistes es intermitente. El test de Graham busca Enterobius ante prurito anal. Se trata con metronidazol, tinidazol o nitazoxanida.

▶ VER CLASE 1.04.4.012 Proteína C reactiva

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.16 · Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs)

QUÉ HAY QUE SABER

- Reactante de fase aguda hepático que sube en 6–8 h y peaks a las 48 h; más rápida y sensible que la VHS para evaluar inflamación aguda y su evolución.
- Valores muy altos sugieren infección bacteriana (neumonía, pielonefritis, abscesos, sepsis), aunque también sube en trauma, cirugía, pancreatitis y enfermedades inflamatorias.
- Postoperatorio: sube tras toda cirugía con peak a las 48 h y luego baja; si sigue subiendo entre el 3.er y 5.º día sugiere complicación infecciosa (filtración anastomótica, absceso, infección de herida) y obliga a estudiar con TAC.
- Útil para seguimiento: el descenso indica buena respuesta al tratamiento; un ascenso persistente sugiere falla, absceso o foco no controlado.
- Inespecífica: no distingue por sí sola etiología bacteriana de viral ni reemplaza los cultivos; interpretar con la clínica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 60 años cursa su 4° día postoperatorio de una resección de colon con anastomosis. Su PCR fue de 140 mg/L al 2° día y hoy sube a 290 mg/L, con febrícula y taquicardia de 110 por minuto. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Es la respuesta inflamatoria normal a la cirugía y no requiere estudio

B La PCR solo sirve en infecciones virales

C Una PCR en ascenso después del 3er día sugiere una complicación infecciosa, como filtración anastomótica, y obliga a estudiar (ej. TAC de abdomen)

D Indica con certeza un tromboembolismo pulmonar

E Se debe a la anestesia

Respuesta C. La PCR sube tras cualquier cirugía, con un máximo cercano a las 48 horas, y luego desciende. Si en vez de bajar sigue subiendo entre el 3° y 5° día, sugiere una complicación infecciosa (filtración anastomótica, absceso, infección de herida) y obliga a estudiar, habitualmente con TAC de abdomen y pelvis con contraste.

▶ VER CLASE 1.04.4.014 Pruebas rápidas para diagnóstico de estreptococo grupo A

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.13 · Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

QUÉ HAY QUE SABER

- Test rápido de antígeno de S. pyogenes en hisopado faríngeo: indicado en faringoamigdalitis con McIsaac de 2 a 3 puntos (fiebre, exudado, adenopatías anteriores dolorosas, ausencia de tos, edad 3–14 años); con 0–1 no se estudia.
- Especificidad alta (cerca de 95 %): un resultado positivo permite tratar con penicilina benzatina o amoxicilina por 10 días.
- Sensibilidad 70–90 %: en niños con clínica sugerente, un negativo se confirma con cultivo faríngeo (estándar de oro); en adultos no suele ser necesario.
- No pedir si hay síntomas virales (tos, coriza, conjuntivitis, aftas); la ASO no sirve en el cuadro agudo.
- El objetivo del diagnóstico y del tratamiento es prevenir la fiebre reumática y las complicaciones supuradas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una niña de 7 años presenta fiebre de 38,8 °C, odinofagia, exudado amigdalino y adenopatías cervicales anteriores dolorosas, sin tos ni coriza. El test rápido de antígeno para estreptococo grupo A resulta negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar amoxicilina de todas formas

B Solicitar cultivo faríngeo, por la sensibilidad imperfecta del test rápido en niños

C Descartar definitivamente la etiología estreptocócica

D Indicar azitromicina

E Solicitar ASO

Respuesta B. El test rápido tiene alta especificidad (cerca de 95%), por lo que un positivo permite tratar, pero su sensibilidad es menor (70-90%). En niños, con alta prevalencia de estreptococo y riesgo de fiebre reumática, un negativo con clínica sugerente se confirma con cultivo faríngeo; en adultos no suele ser necesario. La ASO no sirve en el cuadro agudo.

▶ VER CLASE 1.04.4.015 Reacción de polimerasa en cadena

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 2.5 · Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- PCR (reacción de polimerasa en cadena): amplifica ADN o ARN del agente; alta sensibilidad y especificidad, resultado en horas y útil aun con antibiótico previo.
- GeneXpert MTB/RIF: examen inicial de elección en TBC; detecta M. tuberculosis y resistencia a rifampicina (gen rpoB) en menos de 2 h. Prueba inicial preferente en niños, VIH, contactos de resistentes y personal de salud.
- Otras aplicaciones: PCR de VHS en LCR (encefalitis herpética, sensibilidad >95 %), carga viral de VIH y CMV, SARS-CoV-2, paneles respiratorios, PCR de toxina de C. difficile y Chlamydia o gonococo en orina.
- Una PCR positiva detecta material genético pero no siempre infección activa (puede persistir tras la curación); interpretar con la clínica.
- No reemplaza el cultivo cuando se necesita antibiograma completo (por ejemplo el cultivo de Koch en TBC).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 26

Un paciente de 39 años, VIH positivo, que abandonó el tratamiento antiviral hace varios meses, consulta por un cuadro de tos de 2 meses de evolución, asociado a expectoración mucopurulenta, que en ocasiones es hemoptoica, más sensación febril y baja de peso de 3 kilogramos. Al examen físico, se aprecia enflaquecido, con FC: 100x', PA: 110/60 mmHg, FR: 22x', saturación de oxígeno: 93%, T°: 37,5ºC y, en el examen pulmonar, se auscultan crepitaciones y estertores bilaterales. Se solicita radiografía de tórax que se muestra zonas de relleno bilaterales y se solicitan baciloscopías de expectoración que resultan negativas, con muestra hemorrágica. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar TAC de tórax
B Realizar lavado bronquioalveolear
C Realizar broncoscopía
D Solicitar reacción en cadena de polimerasa para tuberculosis en expectoración
E Iniciar tratamiento con ceftriaxona endovenosa

Respuesta D. Clínica de tuberculosis en un paciente con VIH, con baciloscopías negativas en una muestra hemorrágica. La baciloscopía es poco sensible; la PCR (GeneXpert) es más sensible y es la prueba de elección en personas con VIH.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 149

Un paciente de 35 años, en situación de calle, presenta un cuadro de 6 meses de evolución de tos con expectoración mucosa y mucopurulenta, en ocasiones hemoptoica, asociada a malestar general, disnea de esfuerzos, baja de peso y sensación febril. Al examen físico, está enflaquecido, pálido, con T°: 37,5°C, FC: 87x', PA: 110/70 mmHg, FR: 18x'. Su examen pulmonar muestra crépitos bilaterales y algunas sibilancias. Su hemograma muestra hematocrito: 32%, hemoglobina: 10,6 g/dl, leucocitos: 15.600 por mm3, VHS: 60 mm/h, PCR: 120 mg/L y elisa VIH negativo, PCR covid-19 negativa, baciloscopías de expectoración negativas, con muestra hemorrágica y PPD: 20mm. Se realiza una radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente radiopaedia): **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar TAC de tórax
B Solicitar cultivo para bacillus tuberculosis en medio sólido
C Solicitar reacción en cadena de polimerasa para tuberculosis en expectoración
D Repetir la PCR de covid-19 en muestra nasofaríngea
E Realizar fibrobroncoscopía con lavado bronquioalveolar

Respuesta C. Clínica de tuberculosis con baciloscopías negativas: la PCR para tuberculosis (GeneXpert) es más sensible, da resultado rápido y hoy es el examen inicial de elección. El cultivo también sirve, pero tarda semanas.

▶ VER CLASE 1.04.4.016 Serología de enfermedades infecciosas

NIVEL **INTERPRETA Y EMPLEA**

DÓNDE SE ENSEÑA

Infectología 3.4 · Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas
Infectología 4.2 · Enfermedad de Chagas: Aguda, Indeterminada y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Detecta anticuerpos contra el agente: IgM indica infección reciente; IgG, infección pasada o inmunidad (salvo seroconversión o alza de títulos en muestras pareadas).
- Sífilis: VDRL o RPR cuantitativo mide actividad (curación = caída de 4 veces en 6–12 meses); treponémica (FTA-ABS, MHA-TP) confirma y queda positiva de por vida. VDRL bajo con treponémica negativa = falso positivo biológico (LES, embarazo).
- VIH: ELISA de 4.ª generación o test rápido como tamizaje (alta sensibilidad); un resultado reactivo se confirma en el ISP. Considerar el período de ventana.
- Chagas crónico: IgG por dos técnicas (ELISA + IFI o HAI); en el recién nacido la IgG refleja anticuerpos maternos y se usa microhematocrito o PCR. Otras: hidatidosis (apoyo de la imagen), hantavirus (IgM), VEB (IgM VCA), leptospirosis (MAT).
- El test de Widal no confirma fiebre tifoidea; en inmunosuprimidos la serología puede ser falsamente negativa.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 122

Una paciente se realiza exámenes porque su pareja fue diagnosticada de hepatitis B. Tiene AgHBs negativo y anticuerpos anti-HBs (antisuperficie) positivos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Vacunada contra la hepatitis B
B Hepatitis B aguda
C Hepatitis B crónica
D Hepatitis B en período de ventana
E Infección asintomática por virus hepatitis B

Respuesta A. AgHBs negativo descarta infección activa y anti-HBs positivo indica inmunidad. Sin anti-HBc informados, el anti-HBs aislado corresponde a inmunidad por vacuna (una infección resuelta tendría anti-HBc IgG positivo). No hay enfermedad activa ni período de ventana.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 2

Una paciente de 25 años, embarazada, con 12 semanas contadas desde la FUR segura y confiable, se realiza exámenes, entre los que trae un VDRL, que resulta "no reactivo" y un MHA-TP, que resulta "reactivo". **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Administrar penicilina benzatina de inmediato

B Realizar VDRL mensual durante el resto del embarazo

C Controlar con VDRL a las 30 semanas

D Solicitar un FTA-ABS

E Indicar doxiciclina vía oral

Respuesta C. VDRL no reactivo con treponémica (MHA-TP) reactiva: cicatriz serológica de una sífilis tratada. No hay actividad, así que no se trata; se sigue el control prenatal habitual, con el VDRL que corresponde a las 28–30 semanas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de término, adecuado para la edad gestacional, hijo de madre de 28 años con Chagas crónico asintomático confirmado en el control prenatal. Nace vigoroso, afebril, sin visceromegalias ni alteraciones al examen físico. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar serología IgG anti-T. cruzi al recién nacido

B Microhematocrito (o PCR) al nacer

C Iniciar nifurtimox de inmediato sin estudio

D Alta sin estudio, porque el examen físico es normal

E Electrocardiograma y ecocardiograma neonatal

Respuesta B. En el RN hijo de madre con Chagas se hace de inmediato un parasitológico directo (microhematocrito en sangre de cordón o periférica, o PCR). La IgG refleja los anticuerpos maternos transferidos por la placenta. Si es positivo, se trata (curación > 95 %); si es negativo, se repite a los 3 meses o se pide IgG después de los 9–12 meses.

▶ VER CLASE 1.04.4.017 **Urocultivo y antibiograma** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.13 · Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado para confirmar ITU sintomática, en ITU febril o complicada, en niños, embarazadas (tamizaje de bacteriuria asintomática) y antes de procedimientos urológicos; la tira reactiva solo orienta.
- Muestra: segundo chorro con aseo genital; en niños sin control de esfínter, cateterismo vesical o punción suprapúbica. La bolsa recolectora tiene muchos falsos positivos y solo vale si es negativa.
- Interpretación: ≥100.000 UFC/mL en segundo chorro; recuentos menores son significativos por sondeo (habitualmente ≥10.000) y cualquier recuento por punción suprapúbica; varios gérmenes sugieren contaminación.
- Si no se siembra dentro de 2 h, refrigerar a 4 °C. El antibiograma permite ajustar el antibiótico empírico.
- No pedir urocultivos de rutina ni tratar la bacteriuria asintomática, salvo en embarazadas y antes de procedimientos urológicos; la piuria con urocultivo negativo obliga a pensar en TBC urinaria o uretritis.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una lactante de 8 meses, sin control de esfínter, presenta fiebre de 39 °C sin foco de 2 días de evolución. Se sospecha infección urinaria. **¿Cuál es el método más adecuado para obtener la muestra de urocultivo?**

A Bolsa recolectora adhesiva

B No es necesario urocultivo si la tira reactiva es positiva

C Muestra obtenida del pañal

D Orina de segundo chorro espontánea

E Cateterismo vesical (sondeo) con técnica estéril

Respuesta E. En niños sin control de esfínter, el urocultivo se toma por cateterismo vesical (o punción suprapúbica) con técnica estéril. La bolsa recolectora tiene alta tasa de contaminación y falsos positivos; solo es útil si resulta negativa. El urocultivo es indispensable para confirmar la ITU y guiar el antibiótico; la tira reactiva solo orienta.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 4 códigos

▶ VER CLASE 1.04.5.001 **Drenaje de abscesos superficiales** NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.1 · Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: colección fluctuante (absceso, forúnculo grande, adenoflegmón); el antibiótico solo no resuelve una colección.

- Técnica: asepsia y anestesia local, incisión amplia sobre la zona de mayor fluctuación siguiendo líneas de tensión, ruptura de tabiques, lavado con suero, dejar abierto o con mecha y curaciones posteriores.
- Enviar el pus a Gram y cultivo, sobre todo si hay recurrencia o sospecha de SAMR.
- Antibiótico solo si hay celulitis extensa, compromiso sistémico, inmunosupresión o diabetes, o ubicación de riesgo (cara, mano, perineal).
- Derivar a cirugía: abscesos profundos, perianales complejos, de mano o cara, carbunco estafilocócico extenso o sospecha de fascitis necrotizante.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 30 años presenta un absceso de 3 cm en el muslo, fluctuante, con eritema alrededor de 1 cm, sin fiebre ni compromiso sistémico. No es diabético ni inmunosuprimido. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Antibiótico oral solamente por 10 días

B Punción con aguja fina sin drenaje

C Compresas frías y observación

D Incisión y drenaje bajo anestesia local, con lavado de la cavidad

E Hospitalizar para antibiótico endovenoso

Respuesta D. El tratamiento fundamental de un absceso cutáneo fluctuante es la incisión y drenaje: incisión amplia sobre la zona de mayor fluctuación, ruptura de tabiques, lavado con suero y curaciones. Sin celulitis extensa, compromiso sistémico ni inmunosupresión, el antibiótico no es indispensable; sin drenaje, el antibiótico solo no resuelve la colección.

▶ VER CLASE 1.04.5.002 Punción lumbar

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.2 · Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: sospecha de meningitis o encefalitis; también hemorragia subaracnoidea con TAC normal y otras patologías neurológicas.
- TAC previa obligatoria si hay déficit focal, convulsión reciente, Glasgow <10, papiledema o inmunodepresión (riesgo de herniación); en meningitis no retrasar hemocultivos, dexametasona ni antibióticos por la imagen.
- Contraindicaciones: masa o efecto de masa intracraneano, absceso cerebral, infección en el sitio de punción y coagulopatía o trombocitopenia importante.
- Técnica: decúbito lateral en flexión (o sentado), espacio L3-L4 o L4-L5 (línea entre crestas ilíacas), asepsia, medir la presión de apertura y recolectar tubos para citoquímico, Gram, cultivo y PCR o antígenos.
- Complicación más frecuente: cefalea post punción (mejora en decúbito); la más grave, herniación.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 70 años con fiebre de 39 °C, cefalea y rigidez de nuca, que además presenta una crisis convulsiva y hemiparesia derecha. Glasgow 12. **Respecto de la punción lumbar, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Punción lumbar inmediata y antibióticos según el Gram

B Hemocultivos, dexametasona y antibióticos empíricos, y luego TAC de cerebro antes de la punción lumbar

C TAC de cerebro y esperar su resultado para iniciar antibióticos

D Contraindicar definitivamente la punción lumbar

E Punción lumbar con la paciente sentada, sin imágenes previas

Respuesta B. Focalidad neurológica, convulsiones, compromiso de conciencia, inmunosupresión o papiledema obligan a TAC antes de la punción por riesgo de herniación. Pero el antibiótico no se retrasa: hemocultivos, dexametasona y antibióticos empíricos primero; luego TAC y, si no hay efecto de masa, punción lumbar.

▶ VER CLASE 1.04.5.003 Sembrar muestras para cultivo

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.2 · Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

QUÉ HAY QUE SABER

- Tomar las muestras antes del antibiótico siempre que no retrase el tratamiento, con técnica aséptica y en recipiente estéril rotulado.
- Hemocultivos: 2 sets por punciones separadas, con desinfección de la piel y del tapón del frasco.
- LCR para cultivo: no refrigerar (meningococo y Haemophilus son lábiles al frío); enviar de inmediato a temperatura ambiente o mantener en estufa a 35–37 °C.
- Orina: segundo chorro o sondeo; si no se siembra dentro de 2 h, refrigerar a 4 °C para evitar la multiplicación bacteriana.
- Heridas y abscesos: preferir aspirado del pus o tejido profundo antes que tórulas superficiales, que se contaminan con flora de la piel.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Se realiza una punción lumbar a las 3 de la madrugada a un paciente de 25 años con sospecha de meningitis bacteriana. El laboratorio de microbiología procesará la muestra en 2 horas. **¿Cuál es el manejo más adecuado de la muestra de LCR para cultivo?**

A Mantenerla a temperatura ambiente (o en estufa a 35-37 °C) y enviarla lo antes posible

B Refrigerarla a 4 °C hasta su procesamiento

C Congelarla

D Agregarle suero fisiológico para conservarla

E Sembrarla al día siguiente

Respuesta A. El LCR para cultivo no se refrigera, porque N. meningitidis y H. influenzae son lábiles al frío. Se envía de inmediato a temperatura ambiente o se mantiene en estufa a 35-37 °C. En cambio, la orina para urocultivo sí se refrigera si no se siembra dentro de 2 horas, para evitar la multiplicación bacteriana.

▶ VER CLASE 1.04.5.004 Tinción de Gram

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.5 · Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: secreción uretral, LCR, expectoración, pus o líquidos estériles; permite orientar el tratamiento en minutos.
- Técnica: frotis delgado secado y fijado con calor; cristal violeta, lugol, decoloración con alcohol-acetona y safranina; los Gram positivos quedan morados y los Gram negativos rosados.
- Uretritis en hombre sintomático: diplococos Gram negativos intracelulares en PMN confirman gonococo (sensibilidad >95 %); PMN sin bacterias = uretritis no gonocócica (Chlamydia).
- Errores habituales: frotis muy grueso, decoloración excesiva (falsos Gram negativos) o insuficiente, y muestras tomadas tras el antibiótico.
- Toda uretritis se trata con doble cobertura aunque el Gram muestre solo gonococo (ceftriaxona + doxiciclina).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 25 años consulta por secreción uretral purulenta abundante y disuria de 3 días, tras una relación sexual sin preservativo. Se realiza tinción de Gram de la secreción uretral. **¿Qué hallazgo confirma el diagnóstico de uretritis gonocócica?**

A Cocos grampositivos en racimos

B Bacilos grampositivos

C Diplococos gramnegativos intracelulares dentro de polimorfonucleares

D Levaduras con pseudohifas

E Ausencia de leucocitos

Respuesta C. En hombres con uretritis sintomática, el Gram de la secreción con diplococos gramnegativos intracelulares en polimorfonucleares tiene alta sensibilidad y especificidad para gonorrea. Leucocitos sin diplococos indican uretritis no gonocócica (Chlamydia, Mycoplasma). Se trata con ceftriaxona más cobertura de Chlamydia, como doxiciclina.

05
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

83 CÓDIGOS

185 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	38
Situaciones clínicas de urgencia	14
Conocimientos generales	5
Exámenes e imagenología	14
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	12

Situaciones clínicas

38 códigos

▶ VER CLASE **1.05.1.001** **Absceso pulmonar** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 2.4 · Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares

QUÉ HAY QUE SABER

- Absceso pulmonar: cavidad de pared gruesa con nivel hidroaéreo, >85% por aspiración de flora oral (alcohol, epilepsia, sedantes, trastorno deglutorio + sepsis dental).
- Clínica subaguda de semanas: fiebre vespertina, sudoración, baja de peso y vómica purulenta y fétida; simula TBC o cáncer. Ubicación en segmentos dependientes (posterior de lóbulos superiores, apical de inferiores).
- Confirmación: radiografía y TAC de tórax. Polimicrobiano con anaerobios (Fusobacterium, Prevotella, Peptostreptococcus): todo esquema debe cubrirlos.
- Tratamiento médico (85-90% cura): ampicilina/sulbactam 1,5-3 g c/6 h EV y luego amoxicilina/clavulánico 875/125 mg c/8-12 h VO, 4 a 6 semanas en total, hasta el cierre de la cavidad.
- Mayor de 50 años, fumador o desdentado sin factores de aspiración: fibrobroncoscopía para descartar carcinoma (epidermoide cavitado, pared >15 mm) o cuerpo extraño.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar. Cirugía o drenaje solo si >6 cm, refractario o hemoptisis masiva; rotura a pleura (pioneumotórax) exige tubo pleural.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 165

Un paciente alcohólico, fumador de 10 paquetes año, presenta, desde hace 7 días, un cuadro de tos, con expectoración purulenta y fiebre hasta 38°C. Ha evolucionado con empeoramiento de los síntomas. Al examen físico está febril, con apremio respiratorio. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: **El examen más adecuado para proseguir el estudio es:**

A Broncoscopía
B Videotoracoscopía
C TAC de tórax
D PET-TC
E Resonancia magnética nuclear de tórax

Respuesta C. La radiografía mostraba un absceso pulmonar gigante. La TAC de tórax lo caracteriza mejor y ayuda a descartar un cáncer subyacente. La broncoscopía viene después, si hay riesgo de cáncer o falla el tratamiento.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años, bebedor excesivo, con mala dentadura, consulta por 3 semanas de fiebre nocturna, baja de peso de 4 kg y tos con expectoración abundante, verde oscura y de olor pestilente. Radiografía: cavidad de 4,5 cm con nivel hidroaéreo horizontal en el segmento posterior del lóbulo superior derecho. Está estable. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A Lobectomía superior derecha
B Ampicilina/sulbactam EV y luego amoxicilina/clavulánico oral, 4 a 6 semanas en total
C Drenaje percutáneo del absceso guiado por TAC
D Ciprofloxacino oral por 7 días y control
E Esquema RHZE por 6 meses

Respuesta B. Absceso pulmonar primario por aspiración (alcohol, mala dentadura, esputo fétido, cavidad con nivel en segmento dependiente). El tratamiento es médico, con cobertura anaerobia, por 4 a 6 semanas: 85–90% cura sin procedimientos. Cirugía y drenaje quedan para la falla médica; el ciprofloxacino no cubre anaerobios.

▶ VER CLASE **1.05.1.002** **Asma bronquial grave** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 1.3 · Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Asma grave: no controlada pese a corticoide inhalado en dosis alta + LABA (escalones 4-5 GINA), o que requiere esa terapia para mantener el control.
- Antes de rotularla, confirmar el diagnóstico con espirometría y corregir lo corregible: técnica inhalatoria (aerocámara), adherencia, tabaco, rinosinusitis, reflujo y obesidad; la mayoría del asma «difícil» no es grave.
- Marcadores de mal pronóstico: crisis graves o intubación previa, ≥2 cursos de corticoide oral al año, uso excesivo de SABA, mala percepción de la disnea.
- Manejo inicial en APS: CI dosis alta/LABA con estrategia MART, plan de acción escrito y cursos cortos de prednisona en exacerbaciones; evitar el corticoide oral crónico por su toxicidad.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar para fenotipificar (eosinófilos, IgE) y agregar tiotropio o biológicos (anti-IgE, anti-IL5).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 35 años con asma desde la adolescencia, en tratamiento con budesonida/formoterol en dosis alta más tiotropio. Se verificó adherencia y técnica inhalatoria correctas, y se trataron su rinosinusitis y su reflujo. Aun así tuvo 3 cursos de prednisona oral en el último año. Eosinófilos en sangre 480/µL, IgE total elevada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener prednisona oral 20 mg/día indefinidamente

B Agregar teofilina como única medida

C Cambiar a salbutamol en horario cada 4 horas

D Suspender el corticoide inhalado por falta de respuesta

E Derivar a broncopulmonar para evaluar terapia biológica

Respuesta E. Asma grave: no controlada pese a corticoide inhalado en dosis alta con LABA, habiendo corregido adherencia, técnica y comorbilidades. Con fenotipo eosinofílico corresponde derivar a especialista para biológicos (anti-IL5 o anti-IgE). El corticoide oral crónico es la última opción por su toxicidad.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 42 años con asma, en tratamiento con fluticasona/salmeterol en dosis media. Refiere síntomas diurnos casi diarios, despertares nocturnos semanales y 2 crisis en el año. Al observarlo usar su inhalador presurizado, dispara sin coordinar con la inspiración y no hace apnea. Retira sus inhaladores en forma irregular. **Antes de catalogarlo como asma grave y subir de escalón, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Agregar prednisona oral en dosis bajas permanentes

B Corregir la técnica inhalatoria (por ejemplo, con aerocámara) y reforzar la adherencia

C Derivar de inmediato para terapia biológica

D Agregar montelukast y teofilina

E Cambiar a salbutamol nebulizado en horario

Respuesta B. La mayoría del asma 'difícil' no es grave: es mala técnica, mala adherencia o comorbilidades no tratadas. Antes de subir de escalón o hablar de asma grave hay que corregir la técnica (aerocámara con el presurizado), reforzar la adherencia y reevaluar en semanas.

▶ VER CLASE 1.05.1.003 Asma bronquial leve y moderada

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 1.3 · Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico: síntomas variables (sibilancias, disnea, opresión, tos) + espirometría con respuesta broncodilatadora (VEF1 sube >12% y >200 mL). Espirometría normal no descarta: variabilidad del PEF >10% o metacolina (caída del VEF1 >20%).
- Control GINA en las últimas 4 semanas: síntomas diurnos >2/semana, despertar nocturno, rescate >2/semana, limitación de actividad. 0 = controlada; 1-2 = parcial; 3-4 = no controlada.
- Nunca SABA en monoterapia (más crisis graves y muerte): todo asmático recibe corticoide inhalado desde el primer escalón.
- Escalones 1-2: budesonida/formoterol 160/4,5 mcg 1 puff a demanda; escalón 3: CI/formoterol diario dosis baja + rescate (MART). Vía alternativa: CI diario + salbutamol SOS.
- Si no hay control, revisar técnica, adherencia y comorbilidades antes de subir un escalón; si está controlado ≥3 meses, intentar bajar.
- Seguimiento completo en APS: controles periódicos con evaluación del control, técnica inhalatoria, plan de acción y vacunas (influenza, neumococo); derivar si llega a escalón 4-5.

PREGUNTAS · 12

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 76

Paciente de 45 años, fumadora activa de 40 paquetes año, consulta por tos irritativa asociada a disnea y crisis de sibilancias que aparecen en relación a la actividad física e infecciones respiratorias. Se realiza una espirometría que muestra: Basal: VEF1/CVF: 62% VEF1: 2,4L (62% del valor teórico) CVF: 4,9L (92% del valor teórico) Post-Salbutamol VEF1/CVF: 74% VEF1: 3,6L (89% del valor teórico) CVF: 5,0L (95% del valor teórico) **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Asma

B EPOC

C Fibrosis pulmonar

D Bronquiectasias

E Bronquitis crónica

Respuesta A. Patrón obstructivo (VEF1/CVF 62%) que revierte con broncodilatador: el VEF1 sube 1,2 L (50%) y la relación se normaliza a 74%. Es una obstrucción reversible, es decir, asma, aunque la paciente fume.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 19

Una paciente con antecedente de rinitis alérgica y asma consulta por disnea frecuente, asociada a respiración sibilante y tos, que aparece con frecuencia luego de exponerse a los alergenos, en la noche, cuando cursa con alguna infección respiratoria alta o después de realizar ejercicio. Al examen físico tiene FR: 13 rpm, satura 96% a FiO2 ambiental y en su examen pulmonar destacan sibilancias espiratorias bilaterales. **¿Cuál es la conducta más adecuada con ella?**

A Evitar los alergenos por 3 meses

B Iniciar salmeterol 2 puff cada 12 horas

C Iniciar salbutamol 2 puff cada 6 horas

D Iniciar fluticasona 2 puff cada 12 horas

E Iniciar terapia de desensibilización a los alergenos

Respuesta D. Asma con síntomas frecuentes, incluidos nocturnos: necesita tratamiento antiinflamatorio de mantención con corticoide inhalado, con un broncodilatador de rescate. El salbutamol en horario y el LABA solo no tratan la inflamación.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 32 años con asma, en tratamiento solo con salbutamol inhalado a demanda. En el último mes tuvo síntomas diurnos 4 días a la semana, despertó 2 veces por tos y usa salbutamol casi todos los días. No refiere limitación de actividad. Espirometría: VEF1 72% con respuesta broncodilatadora positiva. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener salbutamol a demanda y citar en 3 meses

B Indicar salbutamol en horario cada 6 horas

C Iniciar corticoide inhalado en dosis baja con LABA, o budesonida/formoterol

D Prednisona oral 40 mg al día por 1 mes

E Derivar para terapia biológica anti-IgE

Respuesta C. Tres criterios GINA (síntomas diurnos > 2/semana, despertar nocturno, rescate > 2/semana): asma no controlada, en monoterapia con SABA, que está proscrita. Hay que iniciar tratamiento antiinflamatorio de mantención: CI en dosis baja + LABA, o budesonida/formoterol según la vía preferida.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 27

Un paciente de 58 años, fumador de 10 paquetes año, consulta por disnea, asociada a tos y expectoración mucosa. Los síntomas aumentan especialmente en relación a la actividad física y cuando presenta infecciones respiratorias. En su examen físico se auscultan escasas sibilancias bilaterales y espiración prolongada. Se solicita una espirometría que muestra: Basal Postbroncodilatador CVF 5.928cc 100% 6.106cc 103% VEF1 4.163cc 76% 5.040cc 92% VEF1/CVF 65% 73% Su radiografía de tórax se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A Asma bronquial

B Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

C Bronquiectasias

D Bronquitis crónica

E Enfermedad pulmonar intersticial difusa

Respuesta A. Diagnóstico: Asma bronquial (opción A). Tiene un cuadro clínico y espirometría (patrón obstructivo que mejora con BD) compatibles con asma. La enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC) es una mezcla de manifestaciones de artritis reumatoide (artritis), lupus (úlceras orales, rash malar, pericarditis, lupus cutáneo subagudo), esclerodermia (fenómeno de Raynaud, disfagia, esclerodactilia) y miositis (como en la polimiositis/dermatomiositis), pudiendo además complicarse con síndrome de Sjögren.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 17

Una paciente de 43 años, ex fumadora de 8 paquetes año, consulta por disnea, aso- ciada a tos con expectoración mucosa y respiración sibilante, que aparecen después de realizar ejercicio o presentar infecciones virales. Al examen físico presenta disminu- ción del murmullo pulmonar, sibilancias espiratorias y aumento del diámetro antero- posterior toráxico. Se realiza una radiografía que se muestra a continuación: INSERTAR FOTO El tratamiento inicial más adecuado es:

A Salmeterol inhalado

B Ipratropio inhalado

C Budesonida inhalado

D Salbutamol inhalado

E Tiotropio inhalado

Respuesta D. Es un asma y lo más correcto es iniciar salbutamol SOS, más un corticoide inhala- do (budesonida en este caso). Por tanto es una mala pregunta. Si fuerzan a elegir el tra- tamiento “inicial”, yo creo que la respuesta es salbutamol.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 68

años de evolución. En ocasiones, los síntomas aumentan significativamente, especialmente en relación a la actividad física y cuando presenta infecciones respiratorias. En su examen físico se auscultan escasas sibilancias bilaterales y espiración prolongada. Se solicita una espirometría que muestra: Basal Postbroncodilatador POE | 5.928cc 100% 6.106cc 103% MEF] ao0o 504000 VEFYCVE jes | [78% | Su radiografía de tórax se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): El diagnóstico más probable es:

A Asma bronquial
B Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
C Bronquiectasias
D Bronquitis crónica
E Enfermedad pulmonar intersticial difusa

Respuesta A. Tiene un asma, por tener un patrón obstructivo (VEF1/CVF menor a 70%), que mejora con broncodilatador (sube más de 15% en cualquiera de los parámetros. Nota: no son 15 puntos porcentuales, sino 15%. Ejemplo, 76% a 92% hay 16 puntos porcentuales, pero subió 21%, ya que 16/76 = 0,21). La radiografía es normal. 10 paquetes-año ya aumenta el riesgo de EPOC y cáncer, pero lo habitual es que estas enfermedades aparezcan sobre 15 paq-año.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 63

Un paciente de 62 años, fumador de 10 paquetes año, consulta por disnea, asociada a tos y expectoración mucosa. Los síntomas aumentan especialmente cuando presenta infecciones respiratorias. En su examen físico se auscultan sibilancias bilaterales y espiración prolongada. Se solicita una espirometría que muestra: Basal Postbroncodilatador CVF 5.810cc 98% 5.870cc 99% VEF1 3.835cc 70% 4.696cc 91% VEF1/CVF 66% 80% Su radiografía de tórax se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A Asma bronquial
B Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
C Bronquiectasias
D Bronquitis crónica
E Enfermedad pulmonar intersticial difusa

Respuesta A. Aunque por la edad y por el tabaquismo podría ser un EPOC, la verdad es que lo habitual es que el EPOC tenga más de 15 paquetes-año y, lo más importante, en este caso la espirometría es un patrón obstructivo que mejora con BD, por lo que está confirmado el diagnóstico de asma.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 146

Una paciente de 24 años presenta tos frecuente y disnea, asociada a sibilancias, que son mayores en la noche y que aumentan con el ejercicio, cuando fuma y en la primavera. Al examen físico presenta espiración prolongada y examen pulmonar con sibilancias bilaterales inspiratorias y espiratorias. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A Evitar la exposición a desencadenantes
B Salbutamol inhalado cada 6 horas
C Budesonida inhalada cada 12 horas
D Salmeterol inhalado cada 12 horas
E Desensibilizar para los alérgenos

Respuesta C. [Pregunta disputada] Es una pregunta técnicamente mala, ya que debe recibir corticoides inhalados (C) más broncodilatadores de corta acción (B) y, dada la abundancia de síntomas, probablemente también de larga acción (D). Además, obviamente debe dejar de fumar (A). De las opciones, tengo la impresión de que la respuesta podría ser C, porque los corticoides son los que previenen la aparición de síntomas, aunque el salbutamol debe indicarse de inmediato, por estar tan sintomático, aunque no cada 6 horas, sino SOS.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 16

Paciente de 22 años con episodios de disnea y sibilancias. Radiografía de tórax PA y lateral: hiperinsuflación bilateral, horizontalización de costillas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Asma bronquial
B Neumotórax espontáneo
C Derrame pleural bilateral
D Neumonía bilateral
E Fibrosis quística

Respuesta A. Hiperinsuflación en radiografía de tórax durante crisis de disnea con sibilancias en joven = asma bronquial. El atrapamiento aéreo produce la imagen de hiperinsuflación.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 127

Un paciente de 38 años, con antecedente de asma bronquial en tratamiento con fluticasona inhalada, 1 puff de 250 mcg cada 12 horas, y salbutamol, 1 puff en caso de necesidad, y rinitis alérgica en tratamiento con loratadina 10 mg al día, presenta aumento de su sintomatología en primavera, requiriendo uso frecuente de salbutamol 2 a 3 veces al día. Al examen físico está en buenas condiciones, eupneico y en su examen pulmonar se auscultan sibilancias bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Aumentar la dosis de flu2casona inhalada
B Indicar salbutamol en horario
C Prohibir la ac2vidad :sica al aire libre
D Agregar inhibidor del receptor de leucotrienos
E Mantener tratamiento

Respuesta A. Es una pregunta discutible, más aún si tomamos en cuenta que distintas guías sobre el tratamiento de asma dicen cosas diferentes. A continuación, el resumen de lo recomendado por la guía GINA: El régimen de elección (Track 1) utiliza MART ("Terapia de Mantención And Rescate"), a base de formoterol + corticoides (budesonida) - Paso 1: MART SOS. - Paso 2: Agregar MART 1 puff al día horario (aceptable mantenerlo solo SOS). - Paso 3: Agregar MART horario. - Paso 4: Subir dosis de cor<coides del...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 15

Paciente de 30 años con tos nocturna y disnea de esfuerzo. Espirometría basal normal. Se realiza test de provocación con metacolina: caída del VEF1 del 22% con dosis de 8 mg/mL. ¿Cuál es el diagnóstico?

A Asma bronquial
B EPOC
C Bronquiectasias
D Fibrosis pulmonar
E Bronquiolitis obliterante

Respuesta A. Caída del VEF1 ≥20% con metacolina = hiperreactividad bronquial = test positivo para asma. Es el gold standard cuando la espirometría basal es normal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 17

Paciente de 25 años con tos y sibilancias recurrentes. Espirometría muestra VEF1/CVF 68% (< 70%), VEF1 72% del predicho. Post broncodilatador: VEF1 aumenta 15% y 220 mL. ¿Cuál es el diagnóstico?

A Asma bronquial
B EPOC leve
C Bronquiectasias
D Fibrosis pulmonar idiopática
E Traqueomalacia

Respuesta A. Obstrucción espirométrica + prueba broncodilatadora positiva (aumento VEF1 ≥12% y ≥200 mL) = asma bronquial. La reversibilidad distingue asma de EPOC.

▶ VER CLASE 1.05.1.004 Bronquiectasias

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.5 · Hemoptisis y Bronquiectasias

QUÉ HAY QUE SABER

- Bronquiectasias: dilatación bronquial permanente por ciclo infección-inflamación; causas: secuela de TBC e infecciones infantiles (sarampión, coqueluche), fibrosis quística, discinesia ciliar, inmunodeficiencias.
- Sospecha: tos crónica con broncorrea purulenta abundante, peor en la mañana, de años; infecciones respiratorias a repetición, hemoptisis recurrente, crépitos y acropaquia.
- Confirmación con TACAR: signo del anillo de sello (bronquio más ancho que su arteria), riel de tranvía, falta de afilamiento periférico. En el joven, buscar la causa (test del sudor).
- Manejo inicial: kinesioterapia respiratoria y drenaje de secreciones, antibiótico en exacerbaciones según cultivo de expectoración, vacuna influenza y neumococo, cesación tabáquica.
- Seguimiento: control periódico en APS con cultivo en exacerbaciones; derivar si hay hemoptisis significativa, exacerbaciones frecuentes o Pseudomonas. Hemoptisis masiva: decúbito sobre el lado que sangra y embolización.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 119

Un paciente de 26 años de edad presenta un cuadro de tos con expectoración de algunos años de evolución, mayor en las mañana y que ha presentado hemoptisis. Su examen físico presenta acropaquias y a la auscultación pulmonar hay crepitaciones y estertores bilaterales. **El diagnóstico más probable es:**

A Bronquiectasias
B Cáncer pulmonar
C Tuberculosis pulmonar
D Asma
E EPOC

Respuesta A. Paciente joven con tos y expectoración de años, mayor en la mañana, hemoptisis, acropaquia y estertores bilaterales: bronquiectasias. La edad y los años de evolución alejan el cáncer y el EPOC.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 87

Paciente con infecciones respiratorias recurrentes y expectoración matinal de 200 mL al día. **¿Cuál es el examen de elección para el estudio?**

A Broncoscopía con lavado broncoalveolar
B Espirometría con test de reversibilidad
C TAC de tórax de alta resolución
D Radiografía de tórax seriada
E Cultivo de esputo

Respuesta C. Broncorrea matinal abundante con infecciones recurrentes: sospecha de bronquiectasias. El examen de elección para confirmarlas es la TACAR (signo del anillo de sello).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 57

Un paciente de 22 años, que desde la infancia tiene infecciones respiratorias a repetición, que requerían uso de antibiótico. Al examen físico, es mesomorfo, con FC: 72x', PA:120/80 mmHg, su examen físico presenta crepitaciones y estertores bilateral. Se solicita radiografía de tórax que muestra múltiples imágenes de dilataciones bronquiales bilaterales, compatibles con bronquiectasias. **¿Cuál es el examen para proseguir el estudio?**

A Broncoscopía con biopsia bronquial
B Prueba de provocación bronquial con metacolina
C Espirometría
D Test del sudor
E Baciloscopías de expectoración

Respuesta D. Adulto joven con infecciones desde la infancia y bronquiectasias bilaterales ya visibles: el siguiente paso es buscar la causa. La fibrosis quística, una de las causas principales de bronquiectasias, se estudia con test del sudor.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 9

Un paciente de 40 años, con antecedente de neumonías a repetición y consumo de tabaco de 5 paquetes-año, consulta por tos frecuente y productiva, mayor durante las mañanas, con expectoración mucosa y, en ocasiones, hemoptoica. Al examen físico presenta dedos en palillo de tambor (acropaquias), frecuencia cardíaca 75 lpm y presión arterial 110/70 mmHg. La auscultación cardiopulmonar revela ritmo regular en dos tonos sin soplos, murmullo pulmonar presente y simétrico, con auscultación de crepitaciones y estertores bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Bronqui2s crónica
B Bronquiectasias
C Carcinoma broncogénico
D Tuberculosis pulmonar
E Insuficiencia cardíaca conges2va

Respuesta B. Tiene un cuadro compatible con bronquiectasias. Se debe revisar el resumen de semiología respiratoria. El diagnóstico se confirma con TAC de tórax de alta resolución.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 107

Una paciente de 45 años, con antecedente de infecciones respiratorias a repetición en la infancia, presenta broncorrea de cerca de 300cc al día, mayor en la mañana, asociada a disnea de esfuerzos y tos con expectoración. Además, refiere cuadros de exacerbación de sus síntomas que ocurren varias veces al año, por lo que usa antibióticos. Al examen físico tiene signos vitales dentro de rango normal y, en la auscultación pulmonar se objetiva espiración prolongada, además de auscultarse estertores y sibilancias bilaterales. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: www.sciencephoto.com): ¿Cuál es el examen de elección para proseguir con el diagnóstico?

A Recuento de inmunoglobulina A, G y M
B TAC de tórax
C Baciloscopías y cultivo para micobacterias
D Lavado bronquioalveolar
E Broncoscopía

Respuesta B. Diagnóstico: TAC de tórax (opción B). El síndrome de Sjögren se manifiesta principalmente con un síndrome de sicca (sequedad), que es su manifestación más frecuente y a veces la única.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 143

Un paciente de 32 años, presenta infecciones respiratorias recurrentes, desde su infancia, que en varias ocasiones han requerido de antibióticos, asociado a disnea de esfuerzos. Al examen físico tiene FC: 80x', PA: 110/70 mmHg, T°: 36,5°C y al examen pulmonar se auscultan múltiples crépitos y sibilancias bilaterales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: Fuente: http://www.lungindia.com/ El examen más adecuado para proseguir el estudio diagnóstico es:

A Fibrobroncoscopía
B Cuantificación de inmunoglobulinas
C TAC de tórax
D Test del sudor
E Espirometría

Respuesta D. Tiene imágenes sugerentes de bronquiectasias bilaterales. El resto del cuadro clínico es compatible con una FQ, a pesar de la edad (neumonías bacterianas a repetición: habitualmente por S. aureus y P. aureginosa).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 18

Una paciente de 23 años, que desde la infancia tiene tos frecuente, con expectoración abundante, mayor en la mañana, que en ocasiones es hemoptoica. Además una o dos veces al año, se exacerba los síntomas, con necesidad de uso de antibióticos. Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación: FOTO (radiografía de tórax AP con afectación en ambas bases, en patrón broncointersticial). ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

A Recuento de inmunoglobulinas
B Test del sudor
C Resonancia magnética de tórax
D TAC de tórax
E Baciloscopías de expectoración

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (TAC de tórax). La clínica es de bronquiectasias, que se diagnostican preferentemente con un TAC de tórax. El síndrome de Sjögren se manifiesta principalmente con un síndrome de sicca (sequedad), que es su manifestación más frecuente y a veces la única.

▶ VER CLASE 1.05.1.005 Bronquitis aguda

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 2.1 · Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65

QUÉ HAY QUE SABER

- Bronquitis aguda: tos con o sin expectoración (incluso purulenta) tras un cuadro viral, sin signos de neumonía; casi siempre viral y autolimitada.
- Diagnóstico clínico: afebril o febrícula, signos vitales normales y examen pulmonar sin focalización (roncus aislados, sin crépitos). No requiere radiografía salvo sospecha de neumonía.
- Pedir radiografía si hay fiebre persistente, taquipnea, taquicardia, hipoxemia, crépitos focales o adulto mayor con compromiso del estado general.
- Tratamiento sintomático: hidratación, paracetamol, miel; salbutamol si hay broncoespasmo. Sin antibióticos: el color del esputo no indica infección bacteriana.
- Educar que la tos puede durar 2-3 semanas. Tos >3 semanas: reevaluar (coqueluche, asma, TBC); >8 semanas es tos crónica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 40 años, sin comorbilidades, consulta por tos con expectoración amarillenta de 10 días, posterior a un cuadro de coriza. Está afebril, con FC 80 por minuto, FR 16 por minuto y saturación 97%; al examen pulmonar hay roncus aislados, sin crépitos. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Amoxicilina por 7 días por la expectoración amarilla
B Corticoides orales
C Radiografía de tórax y levofloxacino
D Manejo sintomático, sin antibióticos, explicando que la tos puede durar hasta 3 semanas
E Azitromicina por 5 días

Respuesta D. Es una bronquitis aguda: tos, con o sin expectoración incluso purulenta, tras una infección viral, sin signos de neumonía (afebril, signos vitales normales, sin focalización). Es mayormente viral y autolimitada, y la tos puede durar 2 a 3 semanas. No requiere radiografía ni antibióticos; el color del esputo no indica infección bacteriana.

▶ VER CLASE 1.05.1.006 Bronquitis crónica

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 1.4 · Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

QUÉ HAY QUE SABER

- Bronquitis crónica: tos productiva al menos 3 meses al año por 2 años consecutivos, descartadas otras causas; típica del fumador, con expectoración mucosa matinal.
- Confirmación: definición clínica + espirometría. Si VEF1/CVF post-BD ≥0,70 es bronquitis crónica sin EPOC; si <0,70, es EPOC con fenotipo bronquítico.
- Radiografía de tórax para descartar cáncer, TBC y bronquiectasias; baciloscopía si hay síntomas respiratorios prolongados.
- Tratamiento: cesación tabáquica (la medida clave), vacuna influenza anual y antineumocócica; broncodilatador si hay disnea; antibiótico solo en exacerbaciones con esputo purulento.

- Seguimiento en APS con espirometría periódica para detectar progresión a EPOC y reforzar la abstinencia tabáquica.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 155

Un paciente de 66 años, fumador de 40 paquetes-año presenta tos con expectoración mucosa, de 4 años de evolución. Tiene broncorrea, mayor en la mañana y presenta 2 infecciones respiratorias al año, que requieren de antibióticos. Su radiografía de tórax y espirometría son normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Cáncer de pulmón
B Tuberculosis pulmonar
C Fibrosis pulmonar
D EPOC
E Bronquitis crónica

Respuesta E. Fumador con tos y expectoración crónicas, mayores en la mañana: bronquitis crónica. No es EPOC porque la espirometría es normal: la EPOC exige VEF1/CVF < 0,70 post-BD.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 155

Un paciente de 66 años, fumador de 40 paquetes-año, presenta tos con expectoración mucosa de 4 años de evolución. Tiene broncorrea, mayor en la mañana, y presenta 2 infecciones respiratorias al año que requieren antibióticos. Su radiografía de tórax y su espirometría son normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Cáncer de pulmón
B Tuberculosis pulmonar
C Fibrosis pulmonar
D EPOC
E Bronquitis crónica

Respuesta E. La bronquitis crónica es tos productiva al menos 3 meses al año por 2 años consecutivos, descartadas otras causas. Sin obstrucción en la espirometría (VEF1/CVF post broncodilatador sobre 0,7) no puede diagnosticarse EPOC, y la radiografía normal hace improbables cáncer, TBC y fibrosis. Lo clave es dejar de fumar.

▶ VER CLASE 1.05.1.007 Cáncer bronquial primario

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.2 · Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en fumador (85-90% de los casos) >40-50 años con tos nueva o que cambia, hemoptisis, baja de peso, neumonía que no resuelve, acropaquia o disfonía.
- No microcítico (85%): adenocarcinoma (periférico, el más frecuente, también en no fumadores), epidermoide (central, cavita, hipercalcemia por PTHrP), células grandes. Microcítico (15%): central, SIADH, Cushing ectópico, Lambert-Eaton.
- Invasión local: Pancoast (dolor C8-T1 + Horner), síndrome de vena cava superior, parálisis recurrencial o frénica, derrame pleural.
- Estudio inicial: radiografía y TAC de tórax; luego biopsia (fibrobroncoscopía o punción) y etapificación con PET-CT y RM cerebral.
- Tratamiento lo define el especialista: no microcítico I-II lobectomía con linfadenectomía; microcítico nunca cirugía de entrada (cisplatino + etopósido + radioterapia).
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar/oncología; el médico general maneja síntomas (hipercalcemia: suero fisiológico + bifosfonato) y apoya la cesación tabáquica.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 11

Un paciente de 76 años, jubilado de la minería y fumador de 20 paquetes año consulta por tos y disnea de 2 meses de evolución, asociada a expectoración mucosa, que a veces tiene estrías de sangre. Ha bajado 4 kilogramos de peso y presenta astenia. Su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar conservado, bilateral, con escasos crépitos y sibilancias, mayores en el lado derecho. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación: [radiografía: nódulo pulmonar]. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?**

A TAC de tórax
B Broncoscopía
C Baciloscopías
D PET
E Resonancia magnética de tórax

Respuesta A. Lo primero es revisar las radiografías previas; luego, la TAC es el examen de elección para enfrentar el nódulo pulmonar. El PET-CT es útil, pero viene después de la TAC; la biopsia por broncoscopía, al final.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 29

Imagen radiográfica de tórax PA en hombre de 62 años, fumador, que muestra masa hiliar derecha irregular con atelectasia del lóbulo superior derecho. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Carcinoma espinocelular (epidermoide) de pulmón

B Derrame pleural

C Neumotórax espontáneo

D Neumonía por aspiración

E Adenocarcinoma periférico

Respuesta A. Masa hiliar central en fumador con atelectasia lobar: carcinoma epidermoide, de localización central, que obstruye el bronquio y colapsa el lóbulo distal. El adenocarcinoma es periférico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 71

Un paciente de 66 años, hipertenso, fumador de 40 paquetes-año consulta por un cuadro de tos, de 2 meses de evolución, con expectoración mucosa o mucopurulenta, en ocasiones hemoptoica asociados a baja de peso. Al examen físico, tiene disminución del murmullo pulmonar bilateral, mayor a derecha, con crepitaciones pulmonar en el lado derecho. Se palpan adenopatías supraclaviculares bilaterales y se constata hipocratismo digital. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 29%, hemoglobina: 9,5 g/dl, leucocitos: 11.000 por mm3, plaquetas: 140.000 por mm3. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: www.medicinainternaaldia.com): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Neumonía multifocal

B Quiste hidatídico

C Atelectasia

D Derrame pleural

E Cáncer pulmonar

Respuesta E. Cáncer de Pulmón: El cuadro clínico y la radiografía sugerían un cáncer de pulmón, pero ninguna de las opciones del Eunacom real tenían dicha respuesta. Así es el Eunacom y no se puede reclamar. Para efectos de subirlo a la plataforma, incluimos la opción.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 90

Paciente fumador con baja de peso, hemoptisis ocasional y dolor costal. Radiografía con masa pulmonar. ¿Diagnóstico más probable?

A Tuberculosis pulmonar cavitada

B Cáncer pulmonar

C Absceso pulmonar

D Sarcoidosis pulmonar

E Linfoma pulmonar primario

Respuesta B. Diagnóstico: Cáncer pulmonar (opción B). Cáncer pulmonar. Esta clase diferencia la fiebre sin foco (FSF) de la fiebre de origen desconocido (FOD).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 144

Una paciente de 63 años, con antecedente de diabetes e hipertensión mal controladas, fumadora de 40 paquetes años y alcohólica activa, consulta por dolor torácico izquierdo, que aumenta con los movimientos respiratorios, asociado a tos con expectoración mucosa, que, en ocasiones es hemoptoica. Ha bajado de peso y refiere disnea de esfuerzos desde hace algunos meses. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca: 65x', PA: 150/98 mmHg, saturación de oxígeno por pulsometría: 95% a FiO2 ambiental, examen pulmonar con murmullo vesicular simétrico, con escasos crépitos a izquierda y, además, refiere dolor a la palpación de quinto arco costal izquierdo. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Absceso pulmonar

B Neumonía neumocócica

C Tuberculosis pulmonar

D Disección aórtica

E Cáncer pulmonar

Respuesta E. Diagnóstico: Cáncer pulmonar (opción E). Esta clase diferencia la fiebre sin foco (FSF) de la fiebre de origen desconocido (FOD).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 136

Un paciente de 60 años, hipertenso, fumador de 25 paquetes-año, consulta por tos de algunos meses de evolución. Su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Se realiza radiografía que se muestra a continuación. NOTA: la foto original no mostraba nada categórico. Era similar a la que se muestra, pero no tenía flecha.

A Cáncer

B Tuberculosis pulmonar

C Fibrosis pulmonar

D Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

E Cardiopatía hipertensiva

Respuesta A. La radiografía no mostraba mucho (en la Rx original no había flecha y se veía, usando la imaginación, un engrosamiento bronquial o mediastínico derecho). Casi se veía normal. Pero tos en alguien muy fumador, con examen físico normal, pensar en Cáncer (no tenía secreción como para pensar en bronquitis crónica por cigarrillo).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 9

Un paciente de 55 años, fumador de 20 paquetes años, consulta por tos de 3 meses de evolución, asociado a disnea y expectoración mucosa. Al examen físico se ausculta murmullo pulmonar conservado, sin ruidos agregados. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Asma bronquial
B Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
C Cáncer bronquial
D Hidatidosis pulmonar
E Enfermedad pulmonar intersticial

Respuesta C. Es un cáncer bronquial o pulmonar clásico, tanto por la clínica, como por la imagen. Revisar el resumen de semiología respiratoria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 7

Un paciente de 60 años, fumador de 40 paquetes años, consulta por disnea de 3 meses de evolución, asociado a tos con expectoración mucosa. Al examen físico tiene FC: 72x', PA: 110/70 mmHg, FR: 15x' y a la auscultación pulmonar se constatan escasos crépitos y algunas sibilancias, que son mayores en el campo pulmonar izquierdo. Se realiza una radiografía, que se muestra a continuación: Fuente: radiopaedia.org ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A Biopsia pulmonar por fibrobroncoscopía
B TAC de tórax
C Fibrobroncoscopía con lavado bronquioalveolar
D Biopsias por videotoracoscopía
E Resonancia magnética nuclear de tórax

Respuesta B. Tiene un tumor pulmonar izquierdo y la clínica sugiere cáncer. Luego de la RxTx se recomienda una TAC, antes de proceder a la biopsia (por broncoscopía, en este caso), ya que que permite ver la ubicación, características y estado de diseminación, además de ayudar a detectar otros diagnósticos diferenciales.

▶ VER CLASE 1.05.1.008 Corazón pulmonar crónico

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 1.4 · Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

QUÉ HAY QUE SABER

- Cor pulmonale crónico: hipertrofia y falla del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad pulmonar con hipoxemia crónica, sobre todo EPOC.
- Clínica: disnea progresiva, edema de extremidades inferiores, ingurgitación yugular, hepatomegalia y reflujo hepatoyugular, con función izquierda conservada.
- Confirmación: ecocardiograma con cavidades derechas dilatadas/hipertróficas y PSAP elevada; ECG con signos de sobrecarga derecha; gases arteriales con hipoxemia; poliglobulia.
- Oxigenoterapia ≥15 h/día: única medida que mejora la sobrevida; indicada con PaO2 ≤55 mmHg, o 56-59 mmHg con cor pulmonale o hematocrito >55%.
- Manejo inicial: optimizar la enfermedad de base, diuréticos para el edema, cesación tabáquica; la digoxina no se indica salvo FA.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar para evaluar oxígeno domiciliario (GES) y estudio de hipertensión pulmonar.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 70 años con EPOC grave presenta edema de extremidades inferiores, ingurgitación yugular y hepatomegalia. El ecocardiograma muestra dilatación del ventrículo derecho y presión de arteria pulmonar estimada de 55 mmHg, con FEVI normal. Gases arteriales en reposo: PaO2 52 mmHg. **¿Cuál es la intervención que ha demostrado mejorar la sobrevida en esta condición?**

A Digoxina
B Oxigenoterapia crónica domiciliaria más de 15 horas al día
C Betabloqueadores
D Anticoagulación oral
E Sildenafil en todos los casos

Respuesta B. El cor pulmonale por EPOC con hipoxemia crónica (PaO2 ≤55 mmHg, o 56-59 con cor pulmonale o poliglobulia) tiene indicación de oxigenoterapia crónica domiciliaria más de 15 horas al día, única intervención que mejora la sobrevida al revertir la vasoconstricción hipóxica. Los diuréticos alivian el edema; la digoxina no se indica salvo FA.

▶ VER CLASE 1.05.1.009 Daño pulmonar secundario a drogas

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.3 · Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar daño pulmonar por fármacos ante disnea progresiva y tos seca con crépitos en usuario de amiodarona, metotrexato, bleomicina o nitrofurantoína crónica.
- Patrón de enfermedad intersticial: crépitos tipo velcro, infiltrados bilaterales en radiografía y vidrio esmerilado o fibrosis en TACAR; disminución de la DLCO.
- Diferenciar de insuficiencia cardíaca (no hay congestión ni edema) y de infección; descartar otras causas de EPID.

- Manejo inicial: suspender el fármaco sospechoso (lo más importante); los corticoides los indica el especialista en casos moderados-severos.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar con TACAR y pruebas funcionales; vigilar función pulmonar en usuarios crónicos de amiodarona.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 106

Una paciente de 68 años, con antecedente de hipertensión y cardiopatía hipertensiva, en tratamiento con losartán y clortalidona, que, además, tiene fibrilación auricular crónica, en tratamiento con amiodarona y rivaroxabán, consulta por un cuadro de disnea progresiva que se ha instalado en los últimos meses, que actualmente es de medianos esfuerzos y se asocia a tos seca, mayor en la noche. Al examen físico tiene pulso regular a 74x', PA: 130/80 mmHg, examen pulmonar con crepitaciones bilaterales, examen cardiaco: RR2T sin soplos, con abdomen y extremidades sin alteraciones. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar salbutamol
B Agregar espironolactona
C Suspender el rivaroxabán
D Suspender la amiodarona
E Agregar furosemida

Respuesta D. Disnea progresiva de meses, tos seca y crepitaciones bilaterales en usuaria de amiodarona, sin signos de congestión: toxicidad pulmonar intersticial por amiodarona. La conducta es suspender el fármaco.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 98

Mujer de 56 años cardiópata y con fibrilación auricular crónica, en tratamiento con espironolactona, isosorbide, hidralazina, amiodarona y anticoagulante oral. Inicia hace 6 meses un cuadro de disnea y tos seca. A la exploración pulmonar tiene crépitos bibasales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A Suspender amiodarona
B Solicitar TAC de tórax
C Aumentar diurético
D Solicitar ecocardiograma
E Solicitar fibrobroncoscopia

Respuesta A. Si bien es imposible ver bien la radiografía, la historia sugería mucho una fibrosis pulmonar por amiodarona, por lo que se debe suspender.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 93

Paciente usuario de amiodarona con disnea progresiva y tos; radiografía con infiltrados bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Suspender amiodarona
B Iniciar corticoides sistémicos
C Agregar antibiótico de amplio espectro
D Solicitar broncoscopía diagnóstica
E Aumentar dosis de amiodarona y agregar corticoide

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Suspender amiodarona (opción A). Suspender amiodarona. Tratamiento: penicilina endovenosa; en forma respiratoria ciprofloxacino + clindamicina.

▶ VER CLASE 1.05.1.010 Derrame pleural neoplásico

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 3.5 · Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Derrame neoplásico: exudado linfocítico con ADA bajo (<40 U/L), a menudo serohemático, en paciente mayor de 50-60 años con baja de peso. Causas: adenocarcinoma pulmonar, mama, linfoma y mesotelioma (asbesto).
- Confirmación: citología del líquido (60% en la 1.ª muestra, 80-85% con la 2.ª). Si es negativa con sospecha alta, biopsia pleural por videotoracoscopía, no repetir citologías indefinidamente.
- Clasificar primero con criterios de Light (proteínas pleura/suero >0,5, LDH pleura/suero >0,6 o LDH >2/3 del límite superior sérico); colesterol pleural alto también orienta a exudado.
- Manejo inicial: toracocentesis evacuadora para aliviar la disnea; es enfermedad avanzada (M1a), el objetivo es paliativo.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar/oncología para pleurodesis con talco o catéter pleural tunelizado y tratamiento del tumor primario.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 87

Un paciente de 56 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disnea progresiva de 2 meses de evolución, asociada a tos irritativa y compromiso del estado general. Sus signos vitales son FC: 88x', PA: 130/80 mmHg, saturación 93% a FiO2 ambiental y al examen pulmonar presenta matidez y crépitos en la base derecha. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural moderado, a derecha, el que se confirma con la TAC de tórax. Se realiza toracocentesis, que da salida a un líquido pleural opalescente, con LDH: 700 UI/L, mayor a 0,6 en relación a la LDH plasmática y proteínas mayores a 0,5, en relación a las proteínas plasmáticas, con 40 células por mm3, 90% de mononucleares, ADA: 24 UI/L y citología negativa. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A Biopsia pulmonar por videotoracoscopía

B Broncoscopía con biopsia pulmonar

C PET-TC

D Biopsia pleural por videotoracoscopía

E Broncoscopía con lavado bronquioalveolar

Respuesta D. Exudado (cumple los criterios de Light), mononuclear, con ADA baja y citología negativa: sugerente de cáncer. Sin tumor pulmonar visible, se biopsia la pleura, idealmente por videotoracoscopía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 116

Un paciente de 68 años presenta tos de 4 meses de evolución, y disnea de esfuerzos. Al examen pulmonar tiene disminución del murmullo pulmonar a derecha, más matidez en la base derecha. Punción pleural con líquido claro, pH: 7,47, células: 70 por mm3, 80% mononucleares, ADA: 20 UI/L, LDH: 167 UI/L, colesterol: 119 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Insuficiencia cardíaca

B Tuberculosis pleural

C Empiema

D Cáncer bronquial

E Derrame secundario a artritis reumatoide

Respuesta D. Aunque la LDH es baja, el colesterol mayor de 40 mg/dL lo clasifica como exudado. Exudado mononuclear con ADA bajo en un adulto mayor: cáncer. La insuficiencia cardíaca da un transudado; la tuberculosis y la artritis reumatoide dan exudados mononucleares con ADA alto; el empiema es un exudado polimorfonuclear.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 20

Un paciente de 60 años, fumador de 5 cigarrillos al día, consulta por disnea de esfuerzos que ha aumentado en el último tiempo. Ha bajado de peso cerca de 6 kilogramos en los últimos 3 meses. Como antecedente, trabajó durante 30 años en una fábrica de producción de pizarras de asbesto para la construcción. Al examen físico presenta signos vitales normales, edema de extremidades inferiores, yugulares visibles al decúbito y examen pulmonar con MP presente, disminuido a derecha. Se solicita una radiografía de tórax que muestra derrame pleural marcado en el lado derecho, por lo que se realiza punción pleural, que da salida a líquido con 300 células por mm3, con 90% de mononucleares, ADA: 22 UI/L, proteínas: 6 g/dL, estudio citológico negativo, pH: 7,37, lactato: 3 mmol/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Carcinoma pavimentoso

B Adenocarcinoma

C Tuberculosis pleural

D Mesotelioma

E Silicosis

Respuesta D. Exudado mononuclear con ADA bajo: derrame neoplásico. El antecedente de 30 años de exposición a asbesto se relaciona fuertemente con mesotelioma. La citología negativa no lo descarta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 120

Paciente de 65 años de edad, fumador de 40 paquetes/año, consulta por disnea progresiva asociada a tos con expectoración escasa mucosa. Al examen físico se aprecia disminución de murmullo pulmonar en base pulmonar izquierda Se solicita radiografía de tórax que muestra derrame pleural en lado izquierdo, el cual se punciona mostrando LDH 250 mg/dL, 300 leucocitos (95% mononucleares) y ADA en 25. El diagnóstico más probable es:

A Insuficiencia Cardiaca

B Derrame pleural maligno

C Tuberculosis

D Tromboembolismo pulmonar

E Enfermedad del tejido conectivo

Respuesta B. Diagnóstico: Derrame pleural maligno (opción B). Exudado mononuclear con ADA baja. Es cáncer. Esta clase aborda la diferenciación entre amigdalitis bacteriana y viral, junto con la difteria y las anginas infecciosas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 176

Un paciente de 45 años consulta por disnea de 2 meses de evolución que ha ido en aumento y se ha asociado a dolor torácico en el hemitórax izquierdo, además de tos seca. Como antecedente, refiere haber vivido gran parte de su infancia junto a una fábrica de fibrocemento. En su examen físico presenta frecuencia cardíaca 82 latidos por minuto, presión arterial 110/70 mmHg, frecuencia respiratoria 22 por minuto; el examen pulmonar muestra abolición del murmullo pulmonar del hemitórax izquierdo y matidez a la percusión en esa zona. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Derrame pleural tuberculoso
B Tromboembolismo pulmonar crónico
C Carcinoma broncogénico
D Silicosis pulmonar
E Mesotelioma maligno

Respuesta E. La radiografía muestra un derrame pleural extenso a izquierda. El antecedente de exposición a asbesto (fibrocemento) orienta al mesotelioma como causa del derrame. Fuente imagen: Radiopaedia.

▶ VER CLASE 1.05.1.011 Derrame pleural paraneumónico complicado

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 3.2 · Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

QUÉ HAY QUE SABER

- Derrame paraneumónico complicado: neumonía con derrame que no resolverá solo con antibiótico (fase fibrinopurulenta). Empiema: pus macroscópico o Gram/cultivo positivo.
- Todo derrame >10 mm en decúbito lateral se punciona. Complicado si pH <7,20 (mejor predictor), glucosa <40-60 mg/dL, LDH >1.000 U/L, tabiques o >½ hemitórax.
- Sospechar ante neumonía que sigue febril a las 72 h de antibiótico adecuado: repetir radiografía/ecografía.
- Conducta inicial: tubo pleural 24-28 Fr a trampa de agua de inmediato, sin esperar respuesta al antibiótico, más antibiótico EV con cobertura anaerobia.
- Esquemas: ampicilina/sulbactam 1,5-3 g c/6 h EV o ceftriaxona 2 g/día + metronidazol 500 mg c/8 h, por 2 a 4 semanas.
- Seguimiento: derivar a cirugía de tórax; si está tabicado, fibrinolíticos intrapleurales o VATS; decorticación solo si hay coraza pleural.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años, tabáquico y con mala dentadura, hospitalizado por neumonía basal derecha en tratamiento con ceftriaxona 2 g/día EV. Al 4.º día persiste febril (38,6 °C), con más dolor pleurítico y disnea. Rx: derrame derecho que ocupa el tercio inferior del hemitórax. Toracocentesis: líquido turbio y espeso, pH 7,12, glucosa 28 mg/dL, LDH 2.450 U/L, Gram con diplococos grampositivos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener ceftriaxona y repetir la toracocentesis en 48 horas
B Tubo de drenaje pleural a trampa de agua y agregar cobertura anaerobia
C Toracotomía con decorticación de urgencia
D Cambiar a ciprofloxacino oral y control ambulatorio
E Fibrinolíticos intrapleurales como primera medida, sin tubo

Respuesta B. pH < 7,20, glucosa < 40 mg/dL, LDH > 1.000 U/L y Gram positivo: derrame complicado que ya es empiema. Indicación inmediata de pleurostomía con tubo a trampa de agua, ajustando el antibiótico con cobertura anaerobia (agregar metronidazol o cambiar a ampicilina/sulbactam).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 156

Un paciente de 50 años presenta un cuadro clínico de 7 días de evolución, caracterizado por tos con expectoración mucopurulenta abundante y fiebre de hasta 38,7°C. El examen físico muestra disminución del murmullo pulmonar, con abolición del murmullo pulmonar en la base derecha. La radiografía de tórax muestra signos de condensación en el lado derecho y derrame pleural de tamaño moderado Se inicia tratamiento con ceftriaxona 2g al día y se realiza toracocentesis, obteniéndose un líquido pleural con 2.000 células/mm3, 85% de polimorfonucleares, colesterol: 70 mg/dL, LDH: 220 U/L, pH: 7.26 y lactato de 6.1 mmol/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar drenaje completo del derrame pleural
B Agregar metronidazol al tratamiento
C Solicitar TAC de tórax
D Solicitar baciloscopías de expectoración
E Realizar broncoscopia y biopsia

Respuesta A. Neumonía con Derrame Paraneumónico: El manejo de una neumonía con derrame paraneumónico complicado (por el lactato pleural > 5 mmol/L) incluye drenaje completo del derrame pleural (medida más importante), tubo pleural y metronidazol para cubrir bacterias anaerobias.

▶ VER CLASE 1.05.1.012 Derrame pleural paraneumónico simple

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 3.2 · Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

QUÉ HAY QUE SABER

- Derrame paraneumónico simple: derrame estéril en fase exudativa, presente hasta en 40% de las neumonías hospitalizadas.
- Confirmación: toracocentesis si mide >10 mm en decúbito lateral; líquido claro, pH >7,20, glucosa >60 mg/dL, LDH <1.000 U/L, Gram y cultivo negativos.

- Tratamiento: solo el antibiótico de la neumonía (ej. ceftriaxona EV si está hospitalizado), sin tubo pleural.
- Vigilancia clínica y ecográfica: si persiste la fiebre a las 72 h o crece el derrame, repuncionar para descartar evolución a complicado.
- Seguimiento completo: control clínico y radiológico hasta la resolución del derrame y de la neumonía (radiografía a las 6-8 semanas en mayores o fumadores).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 138

Un paciente de 50 años presenta un cuadro de tos, con expectoración mucopurulenta y fiebre. Al examen físico está se auscultan crepitaciones basales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra más abajo: NOTA: la radiografía mostraba infiltrados en la base izquierda, que ocupaban el lóbulo inferior izquierdo, pero que permitían ver la cúpula diafragmática, con un pequeño derrame pleural, limitado al ángulo costofrénico. Se punciona el derrame pleural, que muestra un lactato: 2,4 mmol/L, pH: 7,34, con 350 células, 90% de polimorfonucleares. **¿Qué antibiótico debe dejar?**

A Claritromicina
B Clindamicina
C Ceftriaxona
D Azitromicina
E Amoxicilina

Respuesta C. Neumonía con derrame paraneumónico simple (pH > 7,20, derrame pequeño): no requiere tubo. Se maneja hospitalizado, con antibiótico endovenoso: ceftriaxona.

▶ VER CLASE 1.05.1.013 Derrame pleural por tuberculosis

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Infectología 3.3 · Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR
Respiratorio 3.5 · Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Pleuritis tuberculosa: reacción de hipersensibilidad a un foco caseoso subpleural; típica en joven con fiebre, dolor pleurítico, tos seca y baja de peso.
- Líquido: exudado unilateral con >50% de linfocitos (a menudo >80%), escasas células mesoteliales y ADA ≥40 U/L (sensibilidad y especificidad >90%).
- La baciloscopía del líquido es positiva en <5-10% (paucibacilar): no descarta. Biopsia pleural con aguja muestra granulomas caseificantes en >80% si hay duda o ADA limítrofe.
- Exudado linfocítico con ADA alto en un joven basta para iniciar tratamiento: esquema 2 RHZE / 4 RH, directamente observado, 6 meses.
- Notificar y estudiar contactos según el Programa de Control de TBC; buscar TBC pulmonar asociada (baciloscopía y cultivo de expectoración).
- Seguimiento completo: controles mensuales con adherencia, reacciones adversas (hepatotoxicidad, neuritis óptica por etambutol) y evolución radiológica.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 28 años con 4 semanas de fiebre vespertina, tos seca, dolor pleurítico derecho y baja de 4 kg. Radiografía: derrame pleural derecho moderado. Toracocentesis: exudado con 85 % de linfocitos, glucosa 70 mg/dL, ADA 78 U/L y escasas células mesoteliales. Baciloscopía del líquido negativa. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Antibióticos para neumonía y control en 2 semanas
B Esperar el cultivo de Koch del líquido, de 6 a 8 semanas
C Pleurodesis con talco
D Iniciar tratamiento antituberculoso
E Toracoscopía con biopsia pleural antes de tratar

Respuesta D. Exudado linfocitario con ADA alto (sobre 60 U/L) en un adulto joven es diagnóstico de pleuresía tuberculosa y basta para iniciar tratamiento. La baciloscopía y el cultivo del líquido suelen ser negativos porque es una forma paucibacilar. La biopsia pleural se reserva para ADA dudoso o sospecha de cáncer.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 34 años con 3 semanas de fiebre vespertina, dolor pleurítico derecho y baja de 2 kg. Radiografía: derrame pleural derecho. Toracocentesis: exudado con 85 % de linfocitos, glucosa 72 mg/dL, ADA 58 U/L. Baciloscopía del líquido negativa. **¿Cuál es la conducta más adecuada para confirmar el diagnóstico?**

A Repetir la baciloscopía del líquido en 3 muestras
B Biopsia pleural percutánea con aguja
C Citología del líquido pleural seriada
D Pleurodesis con talco
E Broncoscopía con lavado broncoalveolar

Respuesta B. Exudado linfocítico con ADA 58 U/L (≥ 40) en un joven febril: pleuritis tuberculosa. La baciloscopía del líquido es positiva en menos del 10 % porque el derrame es paucibacilar; repetirla no ayuda. La confirmación es la biopsia pleural con aguja (granulomas caseificantes y cultivo).

▶ VER CLASE 1.05.1.014 Edema pulmonar no cardiogénico

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Respiratorio 5.2 · Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín

QUÉ HAY QUE SABER

- Edema pulmonar no cardiogénico (SDRA): edema por aumento de permeabilidad alvéolo-capilar, con shunt e hipoxemia refractaria al oxígeno.
- Causas directas (neumonía, aspiración, contusión, humo) e indirectas (sepsis —la más común—, politrauma, pancreatitis, quemados, transfusiones).
- Criterios de Berlín: inicio ≤7 días tras el insulto, opacidades bilaterales, no explicado por falla cardíaca ni sobrecarga (ecocardiograma) y PaFi ≤300 con PEEP ≥5.
- Gravedad por PaFi: leve 200-300, moderado 100-200, severo ≤100. Diferenciar del edema cardiogénico: cardiomegalia, redistribución y líneas de Kerley.
- Conducta inicial: oxígeno, tratar la causa y trasladar a UCI. Allí: ventilación protectora (Vt 6 mL/kg de peso ideal, plateau ≤30 cmH2O), prono ≥16 h/día si PaFi <150, balance hídrico neutro.
- Seguimiento: manejo por intensivista; derivar siempre.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 38 años, al cuarto día de hospitalización por pancreatitis aguda necrotizante, presenta disnea intensa, FR 34 rpm y cianosis. Rx de tórax: infiltrados alveolares bilaterales difusos. Intubada, con FiO2 80% y PEEP 10 cmH2O, tiene PaO2 72 mmHg. El ecocardiograma muestra función biventricular normal. **¿Cuál es el diagnóstico y la estrategia ventilatoria más adecuada?**

A SDRA moderado; Vt 10 mL/kg de peso real para mejorar la oxigenación

B Edema pulmonar cardiogénico; furosemida y nitroglicerina

C SDRA severo; Vt 6 mL/kg de peso ideal, plateau ≤ 30 cmH2O y prono precoz

D SDRA leve; ventilación no invasiva y alta a sala

E Neumonía aspirativa; antibióticos y supino estricto

Respuesta C. Insulto conocido (pancreatitis) hace < 7 días, opacidades bilaterales, eco normal y PaFi = 72/0,8 = 90 con PEEP ≥ 5: SDRA severo. Ventilación protectora (6 mL/kg de peso ideal, plateau ≤ 30) y, con PaFi < 150, prono ≥ 16 h/día.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 50 años ingresa a la UCI con shock séptico secundario a peritonitis apendicular. Al tercer día de ventilación mecánica invasiva presenta empeoramiento del intercambio gaseoso. La radiografía de tórax revela opacidades alveolo-intersticiales difusas bilaterales que no estaban presentes al ingreso. Con ventilador en modalidad asistida, FiO2 70% y PEEP 8 cmH2O, sus gases arteriales reportan una PaO2 de 63 mmHg (PaFiO2 = 90). El ecocardiograma descarta insuficiencia cardíaca. **¿Cuál es el diagnóstico según los criterios de Berlín y cuál es la estrategia ventilatoria que ha demostrado reducir la mortalidad?**

A SDRA leve; ventilar con volúmenes corrientes de 10 a 12 mL/kg peso real

B SDRA severo; ventilación protectora con volumen corriente de 6 mL/kg peso predicho y posición en decúbito prono precoz

C Edema pulmonar cardiogénico; suspender sedación e indicar digoxina

D Atelectasia masiva izquierda; realizar broncoscopía rígida desobstructiva

E SDRA moderado; mantener al paciente en posición supina estricta y volumen corriente de 8 mL/kg

Respuesta B. Sepsis abdominal, < 7 días, opacidades bilaterales y eco sin falla cardíaca: SDRA. PaFi 90 con PEEP ≥ 5 lo clasifica como severo. Ventilación protectora (6 mL/kg de peso predicho) y prono precoz ≥ 16 h/día (PROSEVA) reducen la mortalidad.

▶ VER CLASE 1.05.1.015 Embolia pulmonar

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.4 · Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante disnea súbita inexplicable (>80%), dolor pleurítico, taquicardia, hemoptisis o síncope, con factores de Virchow: inmovilización, cirugía de cadera/rodilla, cáncer, estrógenos, TVP previa.
- ECG: lo más frecuente es taquicardia sinusal; S1Q3T3 y bloqueo de rama derecha son específicos pero poco frecuentes. Radiografía a menudo normal.
- Paciente estable: Wells ≤4 → dímero D (negativo descarta); Wells >4 → angioTAC directo (dímero D no sirve). Inestable: ecocardiograma en la cama.
- Estratificar con sPESI: 0 = bajo riesgo; ≥1 = ecocardiograma del VD y troponinas.
- Tratamiento inicial: anticoagular apenas se sospecha si no hay contraindicación: rivaroxabán 15 mg c/12 h ×21 días y luego 20 mg/día, o enoxaparina 1 mg/kg c/12 h SC (de elección en cáncer o embarazo).
- Seguimiento: derivar; anticoagulación mínimo 3 meses si es provocado. Filtro de vena cava solo si no se puede anticoagular.

PREGUNTAS · 10

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 121

Un paciente de 56 años, diabético, hospitalizado en su quinto día, por un síndrome nefrótico, presenta un cuadro de disnea y dolor torácico, por lo que se realiza una radiografía de tórax, la que muestra un derrame pleural derecho. Se realiza la punción pleural, dado salida a un líquido pleural de aspecto hemorrágico, con LDH: 650 UI/L, células 80% de polimorfonucleares, 20% de mononucleares, ADA: 30 UI/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Derrame paraneumónico

B Trasudado por hipoalbuminemia

C Empiema

D Tromboembolismo pulmonar

E Derrame pleural canceroso

Respuesta D. Nefrótico hospitalizado con disnea y dolor torácico: TEP. El derrame del TEP suele ser un exudado hemorrágico. Un trasudado por hipoalbuminemia no sería hemorrágico ni tendría LDH de 650.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 5

Un paciente de 68 años presenta una fractura de cadera, de la que es operado. Al segundo día, presenta un síncope, que se recupera al a los pocos segundos. Su presión arterial es de 100/60 mmHg y su frecuencia cardíaca es 110. Además satura 91% a FiO2 ambiental. Su examen físico muestra murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados y un ritmo regular en 2 tiempos, sin soplos. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio?**

A Ecocardiograma
B Radiografía de tórax
C AngioTAC de tórax
D TILT test
E Monitorización electrocardiográfica de 24 horas

Respuesta C. Postoperatorio de fractura de cadera con síncope, taquicardia e hipoxemia y examen pulmonar normal: sospecha de TEP. Con PA sistólica ≥ 90 mmHg puede ir al angioTAC de tórax. Por este riesgo la tromboprofilaxis con HBPM es obligatoria y se extiende 28–35 días.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 148

Un paciente de 72 años es hospitalizado por fractura de cadera, manejada con cirugía de prótesis parcial. Al quinto día presenta pérdida de conciencia, luego de ponerse de pie, con recuperación completa algunos minutos después. Luego de ello presenta lipotimias y episodios similares al incorporarse desde la cama. Al examen físico está con FC: 120x', presión arterial: 100/50 mmHg, extremidades inferiores frías y con cianosis distal y ritmo cardíaco regular, sin soplos y murmullo pulmonar presente. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A TAC de cerebro
B Ecocardiograma
C RMN de cerebro
D Electrocardiograma
E AngioTAC de tórax

Respuesta E. Postoperado de cadera con síncope y taquicardia: TEP. Con presión sistólica sobre 90 mmHg puede ir a la sala de imágenes, y el examen que confirma es el angioTAC. El ecocardiograma en la cama se reserva para el paciente demasiado inestable para trasladarlo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 134

Una paciente consulta al servicio de urgencias por disnea y malestar de 2 horas de evolución. Refiere un viaje reciente en avión desde Europa hace 12 horas y es usuaria de anticonceptivos orales. Al examen físico, tiene presión arterial: 110/70 mmHg, frecuencia cardíaca: 100x' y saturación arterial de oxígeno: 90%, su auscultación cardiopulmonar es normal, al igual que el resto de su examen físico. Se solicita un electrocardiograma que muestra taquicardia sinusal a 120 latidos por minuto. **¿Cuál es el examen de elección para continuar con el estudio?**

A Dímero D
B Ecocardiograma
C AngioTAC de tórax
D Péptido natriurético cerebral
E Electrocardiograma Holter de 24 horas

Respuesta C. Vuelo largo y anticonceptivos, disnea súbita, desaturación y taquicardia sinusal: TEP como diagnóstico más probable (3) + FC > 100 (1,5) = 4,5 puntos de Wells. Probabilidad alta en una paciente estable: angioTAC, no dímero D.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 167

Un paciente de 75 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia cardíaca congestiva en capacidad funcional II, presenta disnea más intensa de la habitual, desde hace 5 días, por lo que ha guardado reposo en cama recibiendo antibióticos y oxigenoterapia. El día de hoy presenta exacerbación súbita de su sintomatología con pérdida de conciencia, que se recupera algunos segundos después, y disnea de reposo. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca 125 latidos por minuto, presión arterial 160/100 mmHg, frecuencia respiratoria 30 por minuto y saturación de oxígeno 87%. El examen pulmonar muestra escasas sibilancias bilaterales y crépitos bibasales. El electrocardiograma muestra taquicardia sinusal sin alteraciones del segmento ST y la radiografía de tórax muestra campos pulmonares grandes, sin opacidades. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Infarto agudo de miocardio
B Disección aórtica
C Taponamiento cardíaco
D Neumonía
E Tromboembolismo pulmonar

Respuesta E. Reposo en cama (estasis) y empeoramiento súbito con síncope: TEP. La taquicardia sinusal es el hallazgo electrocardiográfico más frecuente y la radiografía suele no mostrar alteraciones nuevas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 54 años, operada de artroplastia total de cadera derecha hace 10 días, presenta súbitamente disnea intensa, dolor punzante en hemitórax derecho y taquicardia. FR 26/min, FC 112 lpm, PA 125/80 mmHg, SatO2 91 % ambiental. Pantorrilla derecha aumentada de volumen y dolorosa. **¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?**

A Dímero D ultrasensible y AngioTAC solo si es positivo

B AngioTAC de arterias pulmonares

C Trombólisis con alteplasa sin estudio previo

D Electrocardiograma para buscar S1Q3T3

E Radiografía de tórax y control en 24 horas

Respuesta B. Wells: signos de TVP (3) + TEP como diagnóstico más probable (3) + FC > 100 (1,5) + cirugía reciente (1,5) = 9 puntos, probabilidad alta. Paciente estable: AngioTAC directo, sin dímero D, e iniciar anticoagulación si no hay contraindicación. La trombólisis es solo para el TEP con shock.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 63

Un paciente de 40 años, hospitalizado hace 3 días por un síndrome nefrótico, presenta disnea, de inicio súbito. Presenta desaturación arterial hasta 90%, con disminución del murmullo pulmonar a derecha y matidez, por lo que se realiza una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural. Se punciona el derrame, dando salida a un líquido hemorrágico, con LDH: 700, predominio de polimorfonucleares, pH: 7,3 y lactato de 4,0 mmol/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Empiema

B Derrame paraneumónico simple

C Tromboembolismo pulmonar

D Transudado pleural

E Compromiso pleural maligno

Respuesta C. El exudado hemorrágico orienta a TEP. También el Sd. nefrótico, que se complica con TEP. También el inicio súbito.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 21

Un paciente de 55 años, está hospitalizado por una pancreatitis aguda, de diez días de evolución. Presenta un cuadro de fiebre, malestar general y taquipnea de 1 día de evolución. ¿Qué conducta es más adecuada?

A Solicitar radiografía de tórax

B Solicitar TAC de abdomen y pelvis

C Solicitar ecografía abdominal

D Solicitar angioTAC de tórax

E Solicitar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Solicitar angioTAC de tórax (opción D). La sospecha es un TEP. Es el método diagnóstico de elección debido a su alta sensibilidad (>95%) y capacidad para evaluar complicaciones y extensión anatómica con precisión milimétrica antes de decidir la terapéutica invasiva.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 140

Puérpera de 15 días, inicia disnea y tos, asociada a expectoración, hemoptoica. Al examen pulmonar tiene murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos y satura 90% a FiO2 ambiental. El diagnóstico más probable es:

A Tromboembolismo pulmonar

B Neumonía adquirida en la comunidad

C Neumonía intrahospitalaria

D Tuberculosis pulmonar

E VIH

Respuesta A. Diagnóstico: Tromboembolismo pulmonar (opción A). el antecedente de puerperio orienta muy fuertemente a TEP. La clínica es compatible. La enfermedad de Behçet es una vasculitis cuyas manifestaciones recuerdan a las pelvispondiloartropatías.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 97

Un paciente de 68 años, con antecedente de cáncer de próstata, en tratamiento con hormonoterapia, consulta por un cuadro de 2 días de evolución de dolor torácico, en el lado izquierdo, tipo puntada de costado, asociado a disnea, tos y fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Metástasis pulmonares

B Neumotórax

C Infarto agudo al miocardio

D Tromboembolismo pulmonar

E Distrés respiratorio

Respuesta D. Diagnóstico: Tromboembolismo pulmonar (opción D). Es un TEP clásico. La enfermedad de Behçet es una vasculitis cuyas manifestaciones recuerdan a las pelvispondiloartropatías.

▶ VER CLASE 1.05.1.016 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 1.4 · Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

QUÉ HAY QUE SABER

- EPOC avanzada: VEF1 post-BD <50% (GOLD 3: 30-49%; GOLD 4: <30%), con disnea mMRC ≥2 y a menudo exacerbador (grupo E: ≥2 exacerbaciones moderadas o ≥1 hospitalización al año).
- Confirmación con espirometría (VEF1/CVF post-BD <0,70); evaluar gases arteriales, saturación, hematocrito y ecocardiograma (cor pulmonale).
- Tratamiento inicial: LAMA + LABA; triple terapia (+ CI) solo si es exacerbador con eosinófilos ≥300/µL (o ≥100 con exacerbaciones). Nunca CI en monoterapia.
- Lo que alarga la vida: dejar de fumar y oxígeno ≥15 h/día si PaO2 ≤55 mmHg (o SatO2 ≤88%), o 56-59 con cor pulmonale o hematocrito >55%.
- Rehabilitación pulmonar, vacunas influenza y neumococo, plan de manejo de exacerbaciones.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar (oxígeno domiciliario GES, VMNI domiciliaria, reducción de volumen o trasplante en casos seleccionados).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 66 años, fumador de 35 paquetes-año, con EPOC GOLD 3. Refiere disnea al caminar en plano al ritmo de personas de su edad (mMRC 2). Sin exacerbaciones en el último año. Eosinófilos 90/µL. Gases basales: PaO2 64 mmHg, PaCO2 42 mmHg. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A LAMA + LABA (por ejemplo, tiotropio/olodaterol)

B LAMA + LABA + corticoide inhalado

C Fluticasona inhalada en monoterapia

D LAMA + LABA y oxígeno domiciliario 15 horas al día

E Salbutamol a demanda como única terapia

Respuesta A. Disnea mMRC ≥ 2 sin exacerbaciones: grupo B, que se trata con doble broncodilatación LAMA + LABA. No tiene indicación de CI (eosinófilos < 300, no exacerbador) ni de oxígeno domiciliario (PaO2 > 59 mmHg).

▶ VER CLASE 1.05.1.017 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve y moderada

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 1.4 · Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: fumador >10-20 paquetes-año o expuesto a biomasa con tos, expectoración y disnea de esfuerzo progresiva. Confirmación solo con espirometría: VEF1/CVF post-BD <0,70.
- Fumador con espirometría normal no tiene EPOC. GOLD 1: VEF1 ≥80%; GOLD 2: 50-79%. El tratamiento lo decide el grupo clínico, no el GOLD.
- Grupo A (mMRC 0-1/CAT <10, sin exacerbaciones graves): un broncodilatador de acción larga (LAMA o LABA). Grupo B (mMRC ≥2/CAT ≥10): LAMA + LABA. Grupo E: LAMA + LABA, triple si eosinófilos ≥300.
- Corticoide inhalado en monoterapia contraindicado (más neumonías). SABA solo como rescate.
- Dejar de fumar es la única medida que normaliza la caída del VEF1: consejería + vareniclina o TRN. Vacuna influenza anual y antineumocócica; actividad física y rehabilitación.
- Seguimiento completo en APS (programa ERA): control de síntomas, técnica inhalatoria, exacerbaciones y espirometría anual.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 175

Espirometría con VEF1/CVF 0.35, no mejora post broncodilatador, VEF1 50% **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Fibrosis pulmonar

B Insuficiencia cardiaca derecha

C EPOC

D Asma

E Bronquiectasias

Respuesta C. Relación VEF1/CVF muy baja que no mejora con broncodilatador: obstrucción fija, es decir, EPOC. Con VEF1 de 50%, la limitación es moderada (50–79%).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 14

Un paciente de 65 años, fumador de 40 paquetes año, consulta por disnea de algunos meses de evolución, progresiva, que actualmente le dificulta caminar más de 3 cuadras. Su examen físico demuestra espiración prolongada y algunas sibilancias en ambos campos pulmonares. Actualmente ya no fuma. Se solicita espirometría que muestra lo siguiente: Basal: CVF 2,68 L (90%); VEF1 1,35 L (50%); VEF1/CVF 55. Post SBT: CVF 2,96 L (102%); VEF1 1,38 L (51%); VEF1/CVF 57. **¿Cuál es el tratamiento inicial?**

A Salbutamol inhalado
B Budesonida inhalada
C Ipatropio inhalado
D Fluticasona inhalada
E Tiotropio inhalado

Respuesta E. Obstrucción que no revierte con broncodilatador en un exfumador: EPOC. La base del tratamiento es dejar de fumar y los broncodilatadores de larga acción; de las opciones, el tiotropio (LAMA). Los corticoides inhalados solos están contraindicados.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 135

Un paciente de 55 años, fumados de 30 paquetes-año, consulta por disnea de esfuerzos, progresiva. Su examen físico no muestra alteraciones. Se solicita una radiografía de tórax, que no muestra alteraciones y se realiza una espirometría, que muestra un VEF1 de 60%, que no mejora con broncodilatodor. El diagnóstico más proable es:

A Bronquitis crónica
B Hipertensión pulmonar
C EPOC
D Asma
E Fibrosis pulmonar

Respuesta C. Si bien el Dg. de EPOC se hace con la relación VEF1/CVF (menor a 70%), el VEF1 bajo orienta mucho. Que no mejore con broncodilatador descarta asma y orienta a EPOC. La pregunta en sí está mala, pero probablemente será EPOC la respuesta correcta.

▶ VER CLASE 1.05.1.018

Enfermedades del intersticio pulmonar

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Respiratorio 4.3 · Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática
Reumatología 9.12 · Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar EPID ante disnea de esfuerzo progresiva de meses-años, tos seca, crépitos secos tipo velcro bibasales y acropaquia.
- Examen de elección: TACAR sin contraste. Patrón NIU (panal de abejas subpleural basal, bronquiectasias por tracción) = fibrosis pulmonar idiopática, sin biopsia si es típico en >60 años.
- Patrón NINE (vidrio esmerilado, respeta zona subpleural): buscar conectivopatía (esclerodermia, AR, lupus, miopatías) o fármacos (amiodarona, metotrexato, nitrofurantoína, bleomicina).
- Antes de llamarla idiopática, buscar la causa: exposición laboral (sílice, asbesto), neumonitis por hipersensibilidad, fármacos (suspenderlos).
- FPI: corticoides (con o sin azatioprina) contraindicados, aumentan la mortalidad; se usan antifibróticos (pirfenidona, nintedanib). NINE sí responde a inmunosupresión.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar con TACAR, espirometría y DLCO.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 38

Una paciente de 58 años, hipertensa, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida, consulta por un cuadro de 2 años de evolución de disnea progresiva, que ha aumentado en el último tiempo, volviéndose de pequeños esfuerzos. Además, refiere expectoración mucosa, que suele ser mayor en las mañanas. Evita realizar actividad física, transportar carga y subir escaleras, debido a la disnea. Como antecedente, fumó 4 cigarrillos al día, hasta hace un año. En el examen físico, tiene frecuencia cardíaca: 86 lpm, presión arterial: 120/70 mmHg, frecuencia respiratoria basal: 15 rpm, saturación arterial de oxígeno: 93% a FiO2 ambiental. La auscultación cardíaca muestra ritmo regular en dos tiempos, sin presencia de soplos y la auscultación pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, disminuido de manera global, con presencia de crepitaciones bilaterales. Además, tiene hipocratismo digital. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Asma alérgica
B Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
C Bronquitis crónica por cigarrillo
D Fibrosis pulmonar idiopática
E Insuficiencia cardíaca congestiva

Respuesta D. Disnea progresiva de años, crepitaciones bilaterales e hipocratismo digital en una paciente con tabaquismo mínimo: fibrosis pulmonar idiopática. El EPOC y la bronquitis crónica no explican la acropaquia ni las crepitaciones, y el consumo de tabaco es muy bajo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2022 · PREGUNTA 39

¿Cuál es la principal causa de muerte global en los pacientes con Esclerosis Sistémica Cutánea Difusa en la actualidad?

A Crisis renal esclerodérmica hiperreninémica
B Enfermedad pulmonar intersticial difusa (Fibrosis Pulmonar)
C Rotura de aneurisma aórtico torácico
D Hemorragia digestiva alta por esofagitis péptica
E Amiloidosis renal secundaria

Respuesta B. Históricamente la crisis renal era la primera causa de muerte, pero tras la introducción de los IECA, la principal causa de muerte en la Esclerosis Sistémica Cutánea Difusa es la afectación pulmonar, específicamente la Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa (EPID / fibrosis pulmonar), seguida de la Hipertensión Arterial Pulmonar.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años con disnea de esfuerzo lentamente progresiva desde hace 1 año y tos seca. SatO2 91 % ambiental, acropaquia y crépitos secos teleinspiratorios bibasales tipo velcro. La TACAR muestra reticulación subpleural y múltiples quistes en panal de abejas bibasales, sin vidrio esmerilado. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Biopsia pulmonar quirúrgica para confirmar el diagnóstico
B Prednisona 1 mg/kg/día
C Prednisona más azatioprina
D Iniciar antifibrótico (pirfenidona o nintedanib)
E Broncodilatadores de acción prolongada

Respuesta D. Clínica típica y patrón NIU definitivo en mayor de 60 años: fibrosis pulmonar idiopática sin necesidad de biopsia. Los corticoides (solos o con azatioprina) están contraindicados porque aumentan la mortalidad; se indican antifibróticos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 64

Mujer de 58 años, fumadora e hipertensa, consulta por historia de un año de disnea de esfuerzos moderados y tos seca, no asociado a otros síntomas. Al examen físico destaca acropaquia y al examen pulmonar murmullo pulmonar disminuido bilateral con presencia de crépitos gruesos difusos. Se solicita radiografía de tórax que muestra imagen en panal de abejas. El diagnóstico más probrable es:

A Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
B Tuberculosis
C Enfermedad pulmonar intersticial difusa
D Cáncer pulmonar
E Tromboembolismo pulmonar crónico

Respuesta C. Diagnóstico: Enfermedad pulmonar intersticial difusa (opción C). Es una fibrosis pulmonar. Esta clase aborda la varicela y el herpes zóster, ambos causados por el virus varicela-zóster (VVZ).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 98

Un paciente de 62 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida y fumador de 5 paquetes año, consulta por un cuadro de disnea de esfuerzos de 2 años de evolución, que ha progresado desde entonces. Por ello, en la actualidad, evita subir escaleras y cargar cosas pesadas. Al examen físico se aprecian acropaquías y su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar simétrico, con crepitaciones gruesas bilaterales. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación: Foto 11 (https://radiopaedia.org/cases/XXXXXXXXXXXX-2). El diagnóstico más probable es:

A Neumoconiosis
B Cáncer bronquioloalveolar
C Bronquiectasias
D Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
E Fibrosis pulmonar idiopática

Respuesta E. Diagnóstico: Fibrosis pulmonar idiopática (opción E). Tanto por la clínica, como por la radiografía es una fibrosis pulmonar clásica. Esta clase aborda la varicela y el herpes zóster, ambos causados por el virus varicela-zóster (VVZ).

▶ VER CLASE `1.05.1.019` **Hemoptisis leve y mediana** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.5 · Hemoptisis y Bronquiectasias

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemoptisis: sangre roja y espumosa, alcalina, con tos y carraspeo; diferenciar de hematemesis (oscura, ácida, con restos alimentarios) y epistaxis posterior.
- Leve/mediana: no compromete vía aérea, oxigenación ni hemodinamia (masiva: >150-200 mL/h o >500-600 mL/24 h).
- Causas frecuentes: bronquiectasias, cáncer, TBC, bronquitis, aspergiloma. Estudio inicial: radiografía de tórax, hemograma, coagulación y baciloscopías.
- Mayor de 40 años y fumador: TAC de tórax y fibrobroncoscopía aunque la radiografía sea normal (descartar cáncer).
- Manejo inicial ambulatorio si es leve y estable; tratar la causa (antibiótico si hay infección). Seguimiento: derivar a broncopulmonar para completar estudio.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años, fumador de 40 paquetes-año, consulta por 1 semana de expectoración con estrías de sangre, menos de 20 mL al día. Hemodinámicamente estable, SatO2 97 % ambiental, sin fiebre. Examen pulmonar normal. Radiografía de tórax normal. Pruebas de coagulación normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Estudio ambulatorio con TAC de tórax y fibrobroncoscopía

B Alta sin estudio, porque la radiografía es normal

C Hospitalizar en UCI y embolización de arterias bronquiales

D Ácido tranexámico y control solo si se repite

E Antibiótico por bronquitis y alta sin control

Respuesta A. Hemoptisis leve en un paciente estable se estudia en forma ambulatoria. Mayor de 40 años y gran fumador tiene alto riesgo de cáncer bronquial aun con radiografía normal: se completa con TAC de tórax y fibrobroncoscopía. La embolización se reserva para la hemoptisis masiva.

▶ VER CLASE 1.05.1.020 Hidatidosis pulmonar

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 4.4 · Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Hidatidosis (Echinococcus granulosus): el humano ingiere huevos de heces de perro; quistes en hígado (65-75%) y pulmón (15-25%, bases). Más frecuente en zonas rurales ganaderas del sur.
- Quiste pulmonar intacto suele ser asintomático o da tos y dolor torácico; en la radiografía: imagen redondeada de bordes nítidos.
- Rotura a bronquio: vómica de líquido salado con membranas («hollejos de uva»), a veces hemoptoica; eosinofilia. Signo del camalote (membrana desprendida).
- Estudio: radiografía de tórax primero, luego TAC de tórax y ecografía abdominal (buscar quiste hepático); serología IgG (ELISA, arco 5) como apoyo.
- Tratamiento: cirugía conservadora (quistectomía con capitonaje) + albendazol perioperatorio 10-15 mg/kg/día. La punción percutánea está contraindicada en el pulmón (anafilaxia, siembra).
- Seguimiento: derivar a cirugía de tórax; notificación y educación (no alimentar perros con vísceras crudas, desparasitarlos).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 11

Un paciente de 42 años presenta tos seca de 7 días de evolución que hace 3 días se volvió productiva, con secreción de sabor salado. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca 68 lpm, presión arterial 120/80 mmHg y frecuencia respiratoria 16 rpm. El examen pulmonar muestra matidez en la zona inferior del campo pulmonar derecho, con disminución del murmullo pulmonar en dicha zona. Los exámenes de laboratorio revelan un hematocrito: 38%, plaquetas: 312.000 por mm³, y glóbulos blancos: 12.000 por mm³, con 10% de eosinófilos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Derrame pleural tuberculoso

B Hidatidosis pulmonar

C Absceso pulmonar

D Neumonía

E Carcinoma broncogénico

Respuesta B. Expectoración de sabor salado (vómica) en la base pulmonar con eosinofilia: quiste hidatídico pulmonar roto hacia el bronquio. El quiste pulmonar intacto suele ser asintomático.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 88

Paciente con expectoración hemoptoica y eliminación de contenido 'en uvas'. Radiografía con imagen compatible. ¿Diagnóstico más probable?

A Quiste hidatídico pulmonar

B Absceso pulmonar

C Bronquiectasias

D Cáncer pulmonar cavitado

E Aspergilosis pulmonar invasiva

Respuesta A. Diagnóstico: Quiste hidatídico pulmonar (opción A). Quiste hidatídico pulmonar. Esta clase revisa las infecciones oportunistas del VIH.

▶ VER CLASE 1.05.1.021 Hipertensión pulmonar

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.12 · Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipertensión pulmonar: presión arterial pulmonar media >20 mmHg en cateterismo derecho. Grupos: HAP (grupo 1: idiopática, conectivopatías como CREST), cardiopatía izquierda, enfermedad pulmonar/hipoxemia (EPOC, EPID, SAHOS), tromboembólica crónica y miscelánea.
- Sospecha: disnea de esfuerzo progresiva sin otra explicación, fatiga, síncope de esfuerzo, R2 pulmonar aumentado, signos de falla derecha (edema, ingurgitación yugular, hepatomegalia).
- Estudio: ecocardiograma (PSAP elevada, VD dilatado) como tamizaje; ECG, radiografía, espirometría/DLCO, TAC y cintigrafía V/Q para buscar la causa. Confirmación con cateterismo cardíaco derecho.

- Esclerosis sistémica limitada (CREST, anticentrómero): HAP tardía aislada sin fibrosis en TAC; requiere ecocardiograma anual.
- Manejo inicial: tratar la causa de base, oxígeno si hay hipoxemia (PaO2 ≤55-59 mmHg), diuréticos para la congestión, anticoagulación en la tromboembólica crónica.
- Seguimiento: derivar a centro especializado para vasodilatadores específicos (sildenafil, bosentán, prostanoides).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2023 · PREGUNTA 45

Una mujer de 58 años con antecedente de esclerosis sistémica cutánea limitada (CREST) de 15 años de evolución consulta por disnea de esfuerzo rápidamente progresiva en los últimos 3 meses, sin tos ni ortopnea. El examen pulmonar es limpio sin estertores crepitantes. El ecocardiograma Doppler transtorácico revela dilatación severa de cavidades derechas y una presión sistólica de arteria pulmonar (PSAP) estimada en 65 mmHg. La tomografía computarizada de tórax de alta resolución no muestra infiltrados intersticiales ni fibrosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Neumonía intersticial no específica (NINE)

B Hipertensión Arterial Pulmonar (HTP Grupo 1)

C Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada izquierda

D Tromboembolismo pulmonar crónico recurrente

E Estenosis mitral reumática severa

Respuesta B. En la esclerosis sistémica cutánea limitada (CREST), la complicación visceral tardía más temida es la Hipertensión Arterial Pulmonar (HTP Grupo 1) por vasculopatía proliferativa obliterante de las arterias pulmonares pequeñas, que ocurre en ausencia de enfermedad pulmonar intersticial significativa. Se manifiesta típicamente tras más de 10-15 años de evolución con disnea de esfuerzo progresiva y sobrecarga de cavidades derechas.

▶ VER CLASE 1.05.1.022 Infecciones de las vías aéreas superiores

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.10 · Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

QUÉ HAY QUE SABER

- IVAS: resfrío, faringitis, rinosinusitis, laringitis; >98% virales. Rinosinusitis aguda: ≥2 síntomas (obstrucción, rinorrea purulenta, dolor facial, hiposmia).
- Secreción verde no indica infección bacteriana y no se pide radiografía de senos: el diagnóstico es clínico.
- Rinosinusitis bacteriana si cumple uno: persistencia ≥10 días sin mejoría, doble caída (mejora y recae con fiebre) o inicio severo (fiebre ≥39 °C y pus por 3-4 días).
- Tratamiento: resfrío y gripe sintomáticos (paracetamol, hidratación, lavados con suero). Sinusitis bacteriana: amoxicilina 7-10 días (adultos 1 g c/12 h; niños 80-90 mg/kg/día); con clavulánico si hubo antibiótico reciente, comorbilidad o falla; macrólido en alérgicos.
- Banderas rojas: proptosis, oftalmoplejía dolorosa o baja visual (celulitis orbitaria): hospitalizar, TAC con contraste y antibiótico EV. Seguimiento: control si no mejora a las 48-72 h.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 10

Un paciente de 38 años consulta por malestar general y fiebre de 3 días de evolución, asociada a mialgias, tos seca y rinorrea mucosa abundante. Al examen físico tiene secreción nasal y faringe congestiva y eritematosa. **¿Cuál es el fármaco más adecuado para el manejo de este paciente?**

A Amoxicilina

B Aciclovir

C Acetaminofeno

D Claritromicina

E Prednisona

Respuesta C. Fiebre, mialgias, tos seca, rinorrea y faringe eritematosa sin exudado ni signos de gravedad corresponden a una infección viral de la vía aérea superior (resfrío o síndrome gripal). En un adulto sano el manejo es sintomático con paracetamol, hidratación y reposo. Los antibióticos no están indicados y el aciclovir no actúa sobre virus respiratorios.

▶ VER CLASE 1.05.1.023 Insuficiencia respiratoria crónica

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.1 · Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia respiratoria: PaO2 <60 mmHg (SatO2 <90%) respirando aire ambiental a nivel del mar. Tipo 1 hipoxémica (PaCO2 ≤45) o tipo 2 hipercápnica (PaCO2 >45).
- Crónica: pH casi normal con bicarbonato elevado por compensación renal (ej. EPOC grave: pH 7,37, PaCO2 58, HCO3 33). Causas: EPOC, EPID, enfermedades neuromusculares, obesidad-hipoventilación, deformidades torácicas.
- Gradiente A-a = (150 − PaCO2/0,8) − PaO2: normal (5-15, hasta 20 en ancianos) indica hipoventilación o altura; elevado indica enfermedad pulmonar.
- En retenedores de CO2 titular el oxígeno a SatO2 88-92% (Venturi con FiO2 fija); el exceso de oxígeno empeora la hipercapnia.
- Oxígeno domiciliario ≥15 h/día si PaO2 ≤55 mmHg o 56-59 con cor pulmonale o poliglobulia (aumenta la sobrevida).
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar para oxigenoterapia domiciliaria (GES) o ventilación no invasiva domiciliaria en hipercápnicos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 68 años con EPOC grave, estable y sin exacerbación reciente, tiene gases arteriales en reposo: pH 7,37, PaCO2 58 mmHg, PaO2 58 mmHg y HCO3 33 mEq/L. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Insuficiencia respiratoria crónica global (hipoxémica e hipercápnica) con compensación metabólica

B Acidosis respiratoria aguda descompensada

C Alcalosis metabólica primaria

D Gases arteriales normales

E Acidosis metabólica

Respuesta A. PaO2 bajo 60 mmHg y PaCO2 sobre 45 mmHg definen insuficiencia respiratoria global. El pH casi normal con bicarbonato elevado refleja retención renal de bicarbonato, propia de un proceso crónico compensado; en una acidosis respiratoria aguda el pH estaría claramente bajo. En hipercápnicos crónicos el oxígeno se titula a saturación de 88 a 92%.

▶ VER CLASE 1.05.1.024 Intoxicación leve por CO y otros gases

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.4 · Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo

QUÉ HAY QUE SABER

- Intoxicación por CO: combustión incompleta (brasero, calefón, estufa a gas) en espacio cerrado, típicamente en invierno y con varios convivientes afectados.
- Leve: cefalea holocraneana pulsátil (síntoma más precoz), náuseas, mareo, sin compromiso de conciencia, isquemia ni embarazo. El color rojo cereza es raro y tardío.
- El oxímetro de pulso marca falsamente normal (98-100%): se confirma con carboxihemoglobina por co-oximetría (>3-5% en no fumador, >10% en fumador).
- Tratamiento: oxígeno al 100% con mascarilla de no recirculación a 15 L/min, al menos 6 horas o hasta que cedan los síntomas (vida media de la COHb: 320 min al aire, 80 min con O2 100%). La naricera no sirve.
- Cámara hiperbárica solo si COHb >25%, embarazada >15%, síncope, coma, convulsiones, déficit neurológico, isquemia miocárdica o pH <7,15.
- Evaluar a todos los expuestos, eliminar la fuente y educar en ventilación de la vivienda; control si reaparecen síntomas neurológicos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 40 años, sano, consulta junto a su familia por cefalea leve y náuseas tras pasar la noche con un calefactor a gas en una pieza cerrada. Consciente, orientado, sin focalidad, sin dolor torácico. PA 125/80 mmHg, SatO2 98 % por oxímetro de pulso. ECG normal. Co-oximetría: COHb 9 %. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Alta inmediata, porque la saturación es normal

B Derivar a cámara hiperbárica de inmediato

C Oxígeno al 100 % normobárico con mascarilla con reservorio hasta resolver los síntomas, y evaluar a los convivientes

D Oxígeno por naricera a 1 L/min por 1 hora

E Azul de metileno endovenoso

Respuesta C. Intoxicación leve por CO: síntomas menores, sin compromiso de conciencia, sin isquemia ni embarazo, y COHb menor de 25 %. Se trata con oxígeno al 100 % normobárico (mascarilla con reservorio), que acorta la vida media de la COHb, hasta que cedan los síntomas. Se estudia a los expuestos y se elimina la fuente.

▶ VER CLASE 1.05.1.025 Metástasis pulmonares

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.1 · Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar metástasis ante nódulos pulmonares múltiples, redondeados, bien definidos, de distinto tamaño, periféricos y basales («suelta de globos») en paciente con cáncer previo.
- Primarios frecuentes: colon, mama, riñón, sarcomas, testículo, melanoma, cabeza y cuello. Suelen ser asintomáticas; pueden dar tos, hemoptisis o derrame pleural.
- Estudio: TAC de tórax con contraste (más sensible que la radiografía) y búsqueda del primario si no es conocido; confirmación histológica si cambia la conducta.
- Diferencial: TBC miliar (micronódulos uniformes de 1-3 mm con síntomas sistémicos), granulomatosis con poliangeítis, émbolos sépticos.
- Seguimiento: derivar a oncología; en casos seleccionados con primario controlado y pocas lesiones, metastasectomía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 58 años, operada de un cáncer de colon hace 2 años, presenta en una TAC de control múltiples nódulos pulmonares bilaterales, redondeados, bien definidos, de distintos tamaños y de predominio periférico y basal. Está asintomática. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Tuberculosis miliar
B Neumonía multifocal
C Cáncer pulmonar primario múltiple
D Granulomatosis con poliangeítis
E Metástasis pulmonares hematógenas

Respuesta E. Nódulos múltiples, redondeados, bien definidos, de distintos tamaños, periféricos y basales en un paciente con cáncer previo son metástasis hematógenas hasta demostrar lo contrario (imagen en 'suelta de globos'). El pulmón es sitio frecuente de metástasis de colon, mama, riñón, sarcomas y testículo. La TBC miliar da micronódulos uniformes de 1 a 3 mm con síntomas sistémicos.

▶ VER CLASE 1.05.1.026 Neumoconiosis

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.3 · Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática

QUÉ HAY QUE SABER

- Neumoconiosis: enfermedad pulmonar por inhalación de polvos inorgánicos; en Chile la principal es la silicosis (minería, canteras, arenado), además de asbestosis.
- Sospechar ante disnea progresiva y tos en trabajador expuesto por años, con compromiso intersticial nodular de predominio superior y central y adenopatías hiliares con calcificación «en cáscara de huevo».
- Asbesto: placas pleurales, fibrosis basal, mesotelioma y cáncer pulmonar. La silicosis predispone a tuberculosis y cáncer pulmonar.
- Estudio: anamnesis laboral detallada, radiografía (clasificación OIT), TACAR y espirometría (patrón restrictivo o mixto).
- No tiene tratamiento curativo: retirar de la exposición, dejar de fumar, vacunas, descartar TBC. Notificar como enfermedad profesional.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar y a la mutualidad (Ley 16.744).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 137

Un paciente de 67 años, fumador de 15 paquetes-año que dejó de fumar hace 10 años, jubilado de la minería, consulta por disnea de esfuerzos progresiva de 6 meses de evolución, asociada a tos. Al examen físico presenta murmullo pulmonar globalmente disminuido, sibilancias y roncus bilaterales, asociados a crepitaciones difusas. La radiografía de tórax muestra infiltrados bilaterales, mayores en las zonas centrales, con imágenes verticales onduladas de 1 a 2 cm en ambos campos pulmonares. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Bronquitis crónica
B Neumoconiosis
C Cáncer de pulmón
D Limitación crónica del flujo aéreo
E Fibrosis pulmonar idiopática

Respuesta B. El antecedente laboral en la minería, con disnea progresiva y compromiso intersticial bilateral de predominio central y superior, orienta a neumoconiosis, en Chile principalmente silicosis. La fibrosis pulmonar idiopática compromete las bases y la periferia, y el tabaquismo leve y antiguo no explica el cuadro.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 89

Trabajador de la minería, fumador leve, con disnea, sibilancias, hiperinsuflación y espirometría obstructiva no reversible. ¿Diagnóstico más probable?

A EPOC por tabaquismo
B Asma ocupacional
C Fibrosis pulmonar idiopática
D Silicosis pulmonar
E Neumoconiosis por carbón (antracosis)

Respuesta D. Diagnóstico: Silicosis pulmonar (opción D). Silicosis pulmonar.

▶ VER CLASE 1.05.1.027 Neumonías adquiridas en la comunidad (tipo 4 de la Sociedad Chilena de Enf. Respiratorias)

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 2.1 · Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65
Respiratorio 2.3 · Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa

QUÉ HAY QUE SABER

- NAC tipo 4 (grave, de UCI): CURB-65 ≥3 (4-5: UCI inmediata) o criterios ATS/IDSA. Mayores: shock con vasopresores o necesidad de ventilación invasiva (basta uno).
- Criterios menores (≥3): FR ≥30, PaFi ≤250, infiltrado multilobar, confusión, BUN ≥20, leucocitos <4.000, plaquetas <100.000, T° <36 °C, hipotensión que requiere volumen.

- Confirmación con radiografía de tórax; hemocultivos, gases arteriales, lactato, función renal; GES en ≥65 años.
- Manejo inicial: oxígeno, reanimación con fluidos y antibiótico precoz (<1 h en sepsis): ceftriaxona 2 g/día + levofloxacino 750 mg/día EV (o + azitromicina EV).
- Riesgo de Pseudomonas (bronquiectasias, fibrosis quística, corticoides): piperacilina/tazobactam o cefepime + ciprofloxacino; riesgo de SAMR: agregar vancomicina.
- Seguimiento: derivar a UCI; manejo por especialista.

PREGUNTAS · 11

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 52

Un paciente con antecedente de EPOC, fumador de 25 paquetes año, consulta por cuadro de tres días de evolución de exacerbación de su disnea basal y expectoración mucosa, asociado a sensación febril y hace un día se agrega dolor tipo puntada de costado. Al examen se aprecia frecuencia respiratoria de 21 por minuto, frecuencia cardiaca de 92 por minuto, temperatura de 38,1°C. Al examen pulmonar presenta crepitaciones de la cara lateral del hemitórax derecho, asociado a matidez a la percusión. Se solicita una radiografía de tórax. **El diagnóstico más probable:**

A Tuberculosis
B Derrame pleural
C Neumonía
D Tromboembolismo pulmonar
E Cáncer bronquial

Respuesta C. Cuadro agudo de fiebre, puntada de costado, crepitaciones localizadas y matidez: clínica de NAC, que la radiografía confirma. La matidez puede tentar hacia el derrame, pero las crepitaciones y la fiebre aguda apuntan a condensación.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 139

Un paciente de 60 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y tos, asociada a expectoración mucopurulenta. Evoluciona con dificultad respiratoria, por lo que es llevado al servicio de urgencia. Al examen físico tiene FC: 113x', PA: 100/60 mmHg, FR: 33x' y al examen pulmonar presenta crepitaciones inspiratorias, en el hemicampo pulmonar derecho. La radiografía de tórax muestra condensación en los lóbulos medio e inferior derecho y satura 83%, con FiO2 ambiental, que sube a 90%, con oxígeno al 40%, por mascarilla de recirculación. **¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección para este paciente?**

A Cefepime más amykacina
B Ceftriaxona más clindamicina
C Cloxacilina más metronidazol
D Cefotaximo más moxifloxacino
E Piperacilina más tazobactam

Respuesta D. NAC grave: FR 33, PA 100/60 (diastólica ≤ 60), dos lóbulos comprometidos e insuficiencia respiratoria grave. Es una NAC de UCI, y el esquema es una cefalosporina de tercera generación (cefotaximo o ceftriaxona) más una quinolona respiratoria o un macrólido.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 127

Una paciente de 45 años, hipertensa, presenta un cuadro de 4 días de evolución de malestar general, fiebre hasta 38,8°C, mialgias, cefalea y tos con expectoración mucopuruleta. Al examen físico tiene FR: 13 lpm, FC: 80x'. PA: 120/80 mmHg, examen pulmonar con crépitos en la base izquierda, matidez y aumento de la trasmisión de las vibraciones vocales en la zona. Examen cardíaco normal. Satura 98% a FiO2 ambiental y se solicita una radiografía. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Oseltamivir
B Levofloxacino
C Ceftriaxona
D Amoxicilina
E Claritromicina

Respuesta D. NAC típica (condensación del lóbulo inferior izquierdo), sin criterios de hospitalización, en una menor de 65 años sin comorbilidades relevantes (la hipertensión no agrava la neumonía): amoxicilina sola.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 15

Un paciente de 21 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y tos con expectoración mucopurulenta, de 2 días de evolución. Al examen físico presenta FC: 70x', PA: 120/80 mmHg, FR: 17x' y en la auscultación pulmonar se escuchan crepitaciones en la mitad inferior del campo pulmonar derecho. Satura 93% a FiO2 ambiental y se solicita una radiografía de tórax, que muestra condensación del lóbulo inferior. **¿Cuál es el tratamiento antibiótico más adecuado?**

A Claritromicina
B Cefadroxilo
C Clindamicina
D Cloxacilina
E Ciprofloxacino

Respuesta A. NAC de bajo riesgo en un joven sano. Lo ideal sería amoxicilina, pero no está entre las opciones: el macrólido es la mejor alternativa. Cefadroxilo, cloxacilina y clindamicina no son esquemas de NAC, y el ciprofloxacino no cubre bien al neumococo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 138

Hombre de 75 años con neumonía adquirida en la comunidad. Sin hospitalización reciente ni antibióticos en los últimos 3 meses. Sin alergias. **¿Cuál es el antibiótico de primera línea más adecuado?**

A Amoxicilina-clavulánico oral
B Ciprofloxacino oral
C Clindamicina oral
D Cefalexina oral
E Azitromicina oral

Respuesta A. NAC ambulatoria en mayor de 65 años: amoxicilina/clavulánico 875/125 mg c/12 h por 7 días, por la cobertura de H. influenzae y M. catarrhalis productores de betalactamasa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 105

Un paciente con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica presenta un cuadro de 3 días de evolución, de fiebre hasta 38,9°C, asociada a malestar general, tos, expectoración mucopurulenta y aumento de la disnea. Al examen físico se observa con apremio respiratorio de reposo y se auscultan sibilancias difusas, más crepitaciones en la zona posterior del lóbulo inferior derecho. Se solicita una radiografía de tórax. **¿Qué antibiótico es el más adecuado para el tratamiento de este paciente?**

A Amoxicilina
B Claritromicina
C Clindamicina
D Cefotaximo
E Azitromicina

Respuesta D. Neumonía en un paciente con EPOC y apremio respiratorio de reposo: se hospitaliza, y el esquema de sala es una cefalosporina de tercera generación (ceftriaxona o cefotaximo, con la misma cobertura).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 107

Paciente de 23 años, sin antecedentes, con cuadro de 2 semanas de rinorrea y coriza, que durante los últimos dos días se asocia a compromiso del estado general, sensación febril, tos con expectoración mucopurulenta y disnea. Al examen físico presenta signos vitales dentro de rangos normales, murmullo pulmonar presente en ambos campos pulmonares asociado a crepitaciones en base derecha. Se solicita una radiografía de tórax que muestra infiltrado intersticial en base derecha. **El tratamiento de elección de esta patología es:**

A Claritromicina
B Amoxicilina-ácido clavulánico
C Clindamicina
D Ceftriaxona
E Moxifloxacino

Respuesta A. Joven, cuadro arrastrado de 2 semanas e infiltrado intersticial: sospechar Mycoplasma. Los macrólidos lo cubren bien y son de elección. El moxifloxacino también lo cubre, pero su espectro es innecesariamente amplio.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 153

Un adolescente de 17 años presenta un cuadro de 5 días de evolución de tos con expectoración mucosa, al que se le ha agregado fiebre hasta 37,6°C. Al examen físico está en buenas condiciones, con FR: 15x', saturación oxígeno: 95% y examen pulmonar con murmullo pulmonar presente, auscultándose crepitaciones y sibilancias bilaterales. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Streptococcus pneumoniae
B Mycoplasma pneumoniae
C Chlamydia trachomatis
D Virus influenza
E Pneumocystis jiroveci

Respuesta B. Adolescente en buenas condiciones, con febrícula y compromiso bilateral (crépitos y sibilancias): neumonía atípica, por Mycoplasma pneumoniae, aunque lleve solo 5 días.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 72 años consulta en el CESFAM por 48 horas de fiebre hasta 38,8 °C y tos con expectoración herrumbrosa. Orientada, FR 24 rpm, FC 92 lpm, PA 130/80 mmHg, SatO2 95% ambiental. Crépitos en el tercio inferior derecho. BUN 14 mg/dL. Rx de tórax: condensación del lóbulo inferior derecho, sin derrame. Tiene buena red de apoyo familiar. **¿Cuál es el puntaje CURB-65 y la conducta más adecuada?**

A CURB-65 de 0; tratamiento sintomático sin antibióticos
B CURB-65 de 1; manejo ambulatorio con antibiótico oral y control en 48 horas
C CURB-65 de 2; hospitalización en sala general
D CURB-65 de 1; hospitalización obligatoria por ser mayor de 65 años
E CURB-65 de 3; ingreso a UCI

Respuesta B. Confusión 0, BUN 14 (0), FR 24 (0), PA 130/80 (0), edad ≥ 65 (1): CURB-65 = 1, solo por edad. Estable, sin hipoxemia y con red de apoyo: manejo ambulatorio GES con amoxicilina/clavulánico 875/125 c/12 h por 7 días y control a las 48 horas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 132

IMAGEN: Paciente 66 años con neumonía (clínica e imágen de neumonía monolobar) saturando 94% ¿Cual es el tratamiento?:

A Ceftriaxona b. Amoxicilina con Ac. clavulánico
B Derrame pleural
C Neumotórax
D Neumonía
E Atelectasia

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Ceftriaxona b. Amoxicilina con Ac. clavulánico (opción A).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 100

Una mujer de 63 años, hipertensa, en tratamiento con enalapril y amlodipino, consulta por tos, con expectoración mucopurulenta, de 3 días de evolución. Además, presenta fiebre, malestar general y dolor torácico con la inspiración máxima. Al examen físico, se constata T°: 38 °C, PA: 120/80 mmHg, FC: 80 lpm, FR: 15 rpm, saturación de oxígeno: 97% y en el examen cardiopulmonar destacan crepitaciones localizados en el lado derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: Foto 12 (http://elesfenoides.blogspot.com/2014/07/XXXXXXXXXX-imagenes-1.html) ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A Amoxicilina con ácido clavulánico
B Ceftriaxona
C Levofloxacino
D Clindamicina
E Azitromicina

Respuesta A. Tiene una neumonía del lóbulo superior derecho. En estricto rigor, se puede tratar con amoxicilina, ya que no tiene indicación de ácido clavulánico. Pero de las opciones, la mejor era la A.

▶ VER CLASE 1.05.1.028 Neumonías adquiridas en la comunidad (tipos 1, 2 y 3 de la Sociedad Chilena de Enf. Respiratorias)

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 2.2 · Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES

QUÉ HAY QUE SABER

- NAC: infección aguda del parénquima adquirida fuera del hospital (o <48 h del ingreso); confirmación obligatoria con radiografía de tórax (infiltrado nuevo). GES en ≥65 años.
- Gravedad con CURB-65 (confusión, urea >42 mg/dL, FR ≥30, PAS <90 o PAD ≤60, edad ≥65): 0-1 ambulatorio (si el punto es la edad); 2 hospitalizar en sala. En APS se usa CRB-65.
- Tipo 1 (ambulatorio, <65 años sano): amoxicilina 1 g c/8 h VO 5-7 días; alergia: azitromicina 500 mg/día 3-5 días o claritromicina 500 mg c/12 h.
- Tipo 2 (ambulatorio, ≥65 o comórbido): amoxicilina/clavulánico 875/125 mg c/12 h por 7 días; alternativa cefuroximo 500 mg c/12 h. Atípicos (joven, infiltrado intersticial): macrólido.
- Tipo 3 (sala): ceftriaxona 1-2 g/día EV ± azitromicina; pasar a vía oral si afebril >48 h y estable, completando 7 días.
- Seguimiento completo: control a las 48-72 h; fiebre persistente a las 72 h obliga a buscar derrame complicado, absceso o germen resistente. No se requiere radiografía de control para el alta.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 42 años, previamente sano, no fumador, con 3 días de fiebre hasta 38,6 °C, tos con expectoración mucosa y puntada de costado derecha. SatO2 96%, PA 120/75 mmHg, FR 18 rpm, crépitos en base derecha. Rx de tórax: condensación del lóbulo inferior derecho. CURB-65 = 0. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A Ceftriaxona 1 g intramuscular al día
B Levofloxacino 750 mg al día por vía oral
C Amoxicilina 1 g cada 8 horas por vía oral por 5 a 7 días
D Amoxicilina/clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por 7 días
E Hospitalizar y ceftriaxona más azitromicina endovenosas

Respuesta C. NAC de bajo riesgo (CURB-65 = 0) en un joven sin comorbilidades: manejo ambulatorio con amoxicilina 1 g c/8 h VO por 5–7 días. No se justifican cefalosporinas de tercera generación ni quinolonas de entrada; el clavulánico se reserva para ≥ 65 años o comórbidos.

▶ VER CLASE 1.05.1.029 Neumonías en inmunosuprimidos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.2 · Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en VIH avanzado, quimioterapia, trasplante o corticoides crónicos: gérmenes oportunistas según el grado de inmunosupresión.
- Pneumocystis jirovecii (CD4 <200): disnea subaguda de semanas, tos seca, desaturación al esfuerzo, LDH elevada e infiltrado intersticial bilateral perihiliar (la radiografía puede ser normal).

- Otros: TBC (cualquier CD4), neumococo, aspergilosis en neutropénicos (masa con halo en TAC), CMV. Siempre pedir VIH ante neumonía subaguda en joven enflaquecido.
- Manejo inicial de PCP: cotrimoxazol EV dosis altas (TMP 15-20 mg/kg/día por 21 días) + corticoides si PaO2 <70 mmHg o gradiente A-a ≥35, antes o junto con el antibiótico.
- Prevención: cotrimoxazol forte diario si CD4 <200; se suspende con CD4 >200 por ≥3 meses en TARV.
- Seguimiento: derivar a infectología/hospitalizar; iniciar o reiniciar TARV según especialista.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 34 años con VIH diagnosticado hace 4 años y abandono de TARV. Tos seca de 3 semanas, disnea progresiva, hoy a mínimos esfuerzos, y fiebre vespertina. T° 38,2 °C, FR 28, SatO2 86% ambiental. Rx: infiltrados intersticiales bilaterales perihiliares en vidrio esmerilado. GSA: PaO2 54 mmHg, gradiente A-a 52 mmHg. CD4: 68/mm³. **Además del cotrimoxazol EV en dosis altas, ¿qué medida es indispensable?**

A Corticoides sistémicos antes o junto con el cotrimoxazol

B Agregar azitromicina para cubrir atípicos

C Iniciar corticoides solo si empeora a las 72 horas

D Agregar ganciclovir por posible citomegalovirus

E Iniciar diuréticos de asa para el edema alveolar

Respuesta A. Neumonía por Pneumocystis grave (CD4 < 200) con PaO2 54 mmHg (< 70) y gradiente A-a 52 mmHg (≥ 35): indicación formal de corticoides sistémicos (prednisona o metilprednisolona) antes o junto con el cotrimoxazol. Omitirlos aumenta la mortalidad por el deterioro ventilatorio que sigue a la lisis del hongo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 38

Un paciente de 34 años, consulta por cuadro de 5 semanas de tos irritativa y expectoración que ha ido empeorando, agregándose disnea de medianos esfuerzos. Al examen físico se aprecia enflaquecido, con frecuencia respiratoria de 27 por minuto, frecuencia cardiaca de 90 por minuto, presión arterial de 100/70 mmHg y saturación de 92% con FiO2 ambiental. Examen pulmonar muestra crepitaciones, estertores y algunas sibilancias bilaterales. Se solicita radiografía que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A Fibrosis pulmonar

B Asma bronquial

C Neumonitis viral

D Neumonía por mycoplasma

E Neumonía por Pneumocystis jiroveci

Respuesta E. Es una pregunta difícil, pero que esté enflaquecido más el cuadro clínico, hace que se trate de una neumonía por P. jiroveci. Si hubiese venido sin mayores antecedentes y con un cuadro un poco más corto, sin baja de peso, habría que pensar en Mycoplasma, que puede ser igual. La fibrosis y el asma serían cuadros más crónicos, con radiografías distintas (panal de abejas en fibrosis y normal o hiperinsuflación en asma). La neumonitis viral es aguda.

▶ VER CLASE 1.05.1.030 Neumonías nosocomiales

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 2.3 · Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa

QUÉ HAY QUE SABER

- Neumonía intrahospitalaria: aparece después de 48 h del ingreso y no estaba en incubación; asociada a ventilador si aparece >48 h tras la intubación.
- Diagnóstico: fiebre, secreciones purulentas, deterioro de la oxigenación e infiltrado nuevo en la radiografía; tomar hemocultivos y cultivo de secreción respiratoria antes del antibiótico.
- Gérmenes del hospital: Pseudomonas, Klebsiella BLEE, Acinetobacter y S. aureus resistente (SAMR).
- Tratamiento empírico: piperacilina/tazobactam 4,5 g c/6 h o cefepime 2 g c/8 h EV, + vancomicina si sospecha de SAMR; ajustar según cultivos.
- Prevención: cabecera elevada 30-45°, higiene de manos, aseo oral, retiro precoz de la ventilación y sondas.
- Seguimiento: manejo por especialista e IAAS; derivar.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 74 años ingresa a medicina por una hemorragia digestiva alta. Al quinto día de hospitalización inicia fiebre de 38,6 °C, taquipnea, desaturación y estertores crepitantes en ambos hemitórax. La radiografía de tórax muestra infiltrados nuevos en la base pulmonar izquierda. **¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica más apropiada?**

A Diagnóstico de NAC atípica; tratar con eritromicina oral por 7 días

B Diagnóstico de neumonía intrahospitalaria; hemocultivos y antibióticos antipseudomónicos como piperacilina/tazobactam

C Diagnóstico de embolia grasa; corticoides a altas dosis

D Diagnóstico de bronquitis aguda viral; observación sin antimicrobianos

E Diagnóstico de edema pulmonar cardiogénico; suspender fluidos e indicar amoxicilina oral

Respuesta B. Infiltrado nuevo con fiebre después de 48 horas de hospitalización: neumonía intrahospitalaria. Flora del hospital (Pseudomonas, enterobacterias multirresistentes): cultivos y betalactámico antipseudomónico EV (piperacilina/tazobactam o cefepime).

▶ VER CLASE 1.05.1.031 Neumotórax moderado y grande

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 3.3 · Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario

QUÉ HAY QUE SABER

- Neumotórax: dolor pleurítico súbito y disnea con murmullo disminuido y timpanismo. Primario: varón joven, alto, delgado, fumador (blebs apicales). Secundario: EPOC, TBC, fibrosis, Pneumocystis.
- Confirmación con radiografía de tórax: línea de pleura visceral sin trama periférica. Moderado/grande: ≥2 cm a nivel del hilio (o ≥3 cm en el vértice).
- Primario grande o sintomático: aspiración con aguja o tubo pleural. Secundario: tubo pleural y hospitalización casi siempre, aunque sea pequeño.
- Si hay hipotensión, desviación traqueal o ingurgitación yugular, es a tensión: descompresión inmediata sin esperar radiografía.
- Seguimiento: derivar a cirugía de tórax. VATS con resección de blebs y pleurodesis si es recurrente (2.º episodio), bilateral, con fuga aérea >48-72 h o en profesiones de riesgo (pilotos, buzos).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 80

Paciente de 18 años, sin antecedentes mórbidos, es traído al servicio de urgencias por cuadro de dolor en hemitórax izquierdo de inicio súbito irradiado a miembro superior ipsilateral, asociado a disnea leve, el cual inició mientras jugaba un partido de basquetbol. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones y a la auscultación pulmonar destaca disminución del murmullo pulmonar en hemitórax izquierdo, sin otros síntomas. **El diagnóstico más probable es:**

A Angina inestable

B Tromboembolismo pulmonar

C Neumotorax espontáneo

D Perforación esofágica

E Contractura muscular

Respuesta C. Joven sano, dolor torácico súbito con disnea leve, en buenas condiciones y con murmullo pulmonar disminuido en un hemitórax: neumotórax espontáneo (primario). La asimetría del murmullo es el dato que descarta la contractura muscular.

▶ VER CLASE 1.05.1.032 Neumotórax pequeño

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 3.3 · Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario

QUÉ HAY QUE SABER

- Neumotórax pequeño: separación <2 cm a nivel del hilio (o <3 cm en el vértice) en la radiografía de tórax, en paciente estable y eupneico.
- Primario pequeño y estable: oxígeno a alto flujo (acelera la reabsorción) y observación 4-6 horas; si la radiografía de control no progresa, alta con control.
- Secundario (EPOC, fibrosis, TBC) aunque sea pequeño: tubo pleural y hospitalización, por falta de reserva funcional.
- Educar: evitar viajes en avión y buceo hasta la resolución, consultar si aumenta la disnea; dejar de fumar (reduce la recurrencia).
- Seguimiento: derivar a cirugía de tórax o broncopulmonar; la recurrencia es ~30% tras el primero y >50% tras el segundo (indicación de VATS).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 93

Un paciente de 28 años consulta por dolor torácico derecho, de 2 días de evolución, que aumenta con la inspiración y con la actividad física. Al examen físico está eupneico, con FR: 15x', saturación de oxígeno normal, se aprecia disminución del murmullo pulmonar mayor en el lado derecho. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación: [radiografía: neumotórax derecho pequeño, sin colapso pulmonar]. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Control radiológico en 24 horas

B Solicitar TAC de tórax

C Realizar cirugía abierta

D Drenaje con tubo pleural

E Realizar videotoracoscopía

Respuesta A. Mismas alternativas que la pregunta anterior, pero ahora el neumotórax es pequeño, sin colapso pulmonar, en un paciente eupneico y con saturación normal que lleva 2 días sin agravarse: manejo conservador con control radiológico.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años con EPOC con enfisema buloso consulta por disnea y dolor torácico derecho súbito. FR 26/min, SatO2 88 %, PA 130/80 mmHg. La radiografía de tórax muestra un neumotórax derecho con separación de 1,5 cm a nivel del hilio, sin desviación mediastínica. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Oxígeno por mascarilla y observación por 4 a 6 horas

B Alta con control radiológico en 24 horas

C Instalar tubo de drenaje pleural y hospitalizar

D Punción descompresiva en el 2.º espacio intercostal

E Videotoracoscopía con pleurodesis de urgencia

Respuesta C. Neumotórax espontáneo secundario (EPOC con enfisema buloso). Aunque mide menos de 2 cm, el paciente no tiene reserva funcional: casi siempre requiere tubo de drenaje pleural y hospitalización. La observación con oxígeno es para el primario pequeño y estable; la punción es del neumotórax a tensión.

▶ VER CLASE **1.05.1.033** **Síndrome de apnea del sueño** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.3 · Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)

QUÉ HAY QUE SABER

- SAHOS: colapso faríngeo durante el sueño con apneas (≥10 s) e hipopneas, microdespertares y descarga simpática.
- Sospechar con la tríada: ronquidos fuertes, apneas presenciadas y somnolencia diurna excesiva, en obeso (IMC >30), cuello >43 cm (hombre) o >40 cm (mujer), retrognatia.
- Otros: cefalea matinal, nicturia, alteración de memoria, HTA refractaria, accidentes de tránsito. Epworth >10 indica estudio.
- Confirmación con polisomnografía (o poligrafía en alta probabilidad): IAH leve 5-14, moderado 15-29, severo ≥30.
- Manejo inicial: baja de peso, evitar alcohol, benzodiacepinas e hipnóticos, decúbito lateral; advertir sobre conducción.
- Seguimiento: derivar para confirmación y CPAP nasal nocturno (IAH ≥15, o leve con somnolencia, HTA o chofer profesional).

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 13

Un paciente de 43 años, obeso mórbido, consulta por cansancio y somnolencia diurna. Refiere que ronca en la noche y se queda dormido en las luces rojas del semáforo. En su examen físico destaca PA: 140/90 mmHg, FC: 72x' y faringe normal. **¿Qué examen es el más adecuado para proseguir el estudio en este paciente?**

A Poligrafía nocturna
B Polisomnografía
C Saturación arterial de oxígeno durante el sueño
D Monitorización de presión arterial de 24 horas
E Nasofibroscopía

Respuesta B. Obesidad, ronquidos y somnolencia diurna (se duerme en el semáforo): sospecha de SAHOS. El estándar de oro para confirmarlo y medir el IAH es la polisomnografía nocturna; la poligrafía es una alternativa, no el examen de elección.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 86

Un paciente de 78 años, con sobrepeso, presenta alteraciones de la memoria y dificultades para concentrarse, que iniciaron hace 2 años y que han progresado, asociado a hipersomnia y cansancio. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?**

A Electrocardiograma
B Ecocardiograma
C Polisomnografía
D RMN de cerebro
E TAC de cerebro

Respuesta C. Sobrepeso con hipersomnia y cansancio orientan a SAHOS; el sueño fragmentado explica la falla de memoria y concentración. El examen de elección es la polisomnografía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 81

Un Paciente de 52 años con historia de ronquidos frecuentes, de larga data, que desde hace 5 años, se asocia a somnolencia diurna excesiva y deterioro cognitivo. Al examen físico tiene frecuencia cardiaca de 75x' y presión arterial de 140/100 mmHg. Su IMC es de 35. Se realiza polisomnografía que evidencia índice de apneas de 50 eventos de apnea / hipopnea por hora, con predominio de los eventos obstructivos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Oxígeno nocturno
B C-PAP nocturno
C Cirugía bariátrica
D Uvulopalatoplastía
E Dispositivo orofaríngeo

Respuesta B. IAH 50 (≥ 30): SAHOS severo, obstructivo, con somnolencia e HTA. El tratamiento de elección es el CPAP nasal nocturno. El oxígeno no evita el colapso faríngeo; la cirugía y los dispositivos no son primera línea en el SAHOS severo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 146

Paciente con apnea del sueño, tenía polisomnografía con 65 episodios por hora, hipertrofia de cornetes conducta: **¿Cuál es la conducta?**

A CPAP
B Cirugía de cornetes
C Laparotomía exploratoria
D Cirugía laparoscópica
E Manejo conservador

Respuesta A. IAH 65: SAHOS severo. El CPAP es el tratamiento de elección aunque exista un hallazgo anatómico como la hipertrofia de cornetes; la cirugía de cornetes no resuelve el colapso faríngeo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 50 años, conductor de camiones, IMC 36 kg/m², perímetro de cuello 46 cm, hipertenso con tres fármacos y mal control. Su esposa refiere ronquidos intensos y pausas respiratorias nocturnas. Epworth 15. La polisomnografía muestra un IAH de 42 eventos/hora, de predominio obstructivo. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A Oxigenoterapia nocturna por naricera a 2 L/min

B Zopiclona nocturna para consolidar el sueño

C CPAP nasal nocturno más baja de peso

D Solo baja de peso y control en 6 meses

E Modafinilo diurno en monoterapia

Respuesta C. IAH ≥ 30: SAHOS severo, con HTA refractaria y profesión de riesgo. El tratamiento de elección es CPAP nasal nocturno, siempre acompañado de baja de peso y sin sedantes. La baja de peso sola no basta en un SAHOS severo; los hipnóticos empeoran el colapso faríngeo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 75

Un paciente de 78 años, IMC: 32, presenta alteraciones de la memoria, desde hace 2 años, que han progresado, asociado a desconcentración e hipersomnia. ¿Cuál es el diagnóstico de elección para iniciar el estudio?

A Electrocardiograma

B Ecocardiograma

C Polisomnografía

D RMN de cerebro

E TAC de cerebro

Respuesta C. Que tenga hipersomnia hace sospechar que haya un SAHOS, por lo que se debe estudiar con una polisomnografía.

▶ VER CLASE 1.05.1.034 Síndromes mediastínicos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.2 · Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndromes mediastínicos: compresión o invasión de estructuras del mediastino; causas según compartimento: anterior (timoma, teratoma, linfoma, tiroides «4 T»), medio (adenopatías, quistes), posterior (neurogénicos).
- Síndrome de vena cava superior: edema facial y de brazos que empeora al agacharse, plétora, ingurgitación yugular sin pulso, circulación colateral torácica; causa más frecuente: cáncer pulmonar microcítico y linfoma.
- Otros: disfonía por parálisis recurrencial, disfagia, Horner, estridor, parálisis frénica.
- Estudio: radiografía (ensanchamiento mediastínico), TAC de tórax con contraste y diagnóstico histológico antes de tratar; la radioterapia o corticoides empíricos pueden arruinar la biopsia.
- Estridor, edema cerebral o compromiso de conciencia: emergencia (stent endovascular). Seguimiento: derivar a especialista.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 63 años, fumador de 50 paquetes-año, con 3 semanas de edema facial y de ambos brazos que empeora al agacharse, disnea leve y cefalea matinal. Ingurgitación yugular sin pulso y circulación colateral en la pared torácica anterior. Sin estridor ni compromiso de conciencia. Radiografía: ensanchamiento mediastínico superior derecho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Radioterapia de urgencia antes de cualquier estudio

B Esternotomía exploradora de urgencia

C Corticoides en altas dosis y alta

D Trombólisis sistémica

E TAC de tórax con contraste y obtener diagnóstico histológico antes de tratar

Respuesta E. Síndrome de vena cava superior subagudo, sin estridor ni edema cerebral: no es una emergencia que impida estudiar. Se hace TAC con contraste y se obtiene histología (broncoscopía, biopsia de adenopatía) antes de tratar, porque linfoma y cáncer microcítico se tratan con quimioterapia. La radioterapia empírica arruina la biopsia.

▶ VER CLASE 1.05.1.035 Tos crónica

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 1.3 · Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Tos crónica: duración >8 semanas en adultos. Lo primero: radiografía de tórax, preguntar por tabaco e IECA.
- Con radiografía normal en no fumador, las causas principales son goteo postnasal (rinosinusitis), asma (incluida la variante tos) y reflujo gastroesofágico.
- IECA (enalapril): tos seca en 5-20% por bradicinina; cambiar a ARA II (losartán) y la tos cede en 1-4 semanas.
- Estudio dirigido: espirometría con BD o metacolina si sospecha de asma; tratamiento empírico secuencial según la clínica (corticoide/antihistamínico nasal, CI, IBP).

- Banderas rojas: hemoptisis, baja de peso, fiebre, fumador >40 años o radiografía anormal: descartar cáncer y TBC (baciloscopías).
- Seguimiento completo en APS con reevaluación de la respuesta al tratamiento empírico; derivar si persiste pese al manejo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 58 años, no fumadora, consulta por tos seca persistente de 3 meses. Hace 4 meses inició enalapril por hipertensión arterial. Su radiografía de tórax es normal y no tiene síntomas de reflujo, rinitis ni sibilancias. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar omeprazol empírico

B Solicitar TAC de tórax

C Iniciar un corticoide inhalado

D Suspender el enalapril y cambiar a un ARA II (como losartán)

E Iniciar codeína a permanencia

Respuesta D. La tos crónica (más de 8 semanas) en no fumadores con radiografía normal se debe principalmente a goteo postnasal, asma y reflujo, pero siempre debe descartarse el uso de IECA, que causa tos seca en 5 a 20% de los usuarios por acumulación de bradicinina. Se cambia a un ARA II y la tos cede en 1 a 4 semanas.

▶ VER CLASE 1.05.1.036 Tuberculosis pulmonar

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Infectología 3.3 · Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR
Respiratorio 2.5 · Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Sintomático respiratorio: tos con expectoración ≥2 semanas (15 días); se estudia de inmediato con GeneXpert MTB/RIF (examen inicial), 2 baciloscopías (una inmediata y otra matinal) y cultivo de Koch en todas las muestras.
- Clínica: tos, hemoptisis, fiebre vespertina, sudoración nocturna, baja de peso; radiografía con infiltrados o cavidades en lóbulos superiores. La baciloscopía negativa no descarta.
- Esquema primario (GES, gratuito, tratamiento directamente observado): 2 RHZE diario (50 dosis) + 4 RH; 6 meses. Dosis: R 10 mg/kg (máx. 600), H 5 mg/kg (máx. 300), Z 25 mg/kg, E 15-20 mg/kg.
- Reacciones: R orina anaranjada (benigno, inductor CYP450); H neuropatía (piridoxina 25-50 mg/día); Z la más hepatotóxica e hiperuricemia; E neuritis óptica con alteración rojo-verde (suspender ya).
- Hepatotoxicidad: suspender si transaminasas >5× LSN o >3× con síntomas.
- Seguimiento completo: baciloscopía mensual, notificación obligatoria y estudio de contactos; terapia preventiva en contactos <5 años o VIH.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 48 años, en su 5.ª semana de tratamiento 2RHZE, consulta por visión borrosa bilateral y dificultad para distinguir las luces del semáforo. Agudeza visual 20/60 bilateral, test de Ishihara muy alterado para verde y rojo. Fondo de ojo normal. **¿Cuál es la conducta inmediata?**

A Suspender de inmediato y en forma definitiva el etambutol

B Agregar piridoxina y mantener el esquema

C Suspender la rifampicina por su efecto sobre las secreciones

D Mantener el esquema y controlar en un mes

E Reducir la dosis de isoniazida a la mitad

Respuesta A. Neuritis óptica retrobulbar por etambutol: pérdida de agudeza visual y de la discriminación rojo-verde con fondo de ojo normal. Se suspende de inmediato y en forma definitiva; si se suspende precozmente suele ser reversible, y si se continúa la ceguera puede ser permanente.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 38 años con TBC pulmonar (baciloscopía +++, GeneXpert sin resistencia a rifampicina) en tratamiento observado con RHZE diario. A las 3 semanas consulta por orina de color anaranjado brillante y parestesias dolorosas en los dedos de ambos pies. Pruebas hepáticas normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Suspender la rifampicina por nefrotoxicidad

B Suspender todo el esquema hasta evaluar por neurología

C Agregar piridoxina 25–50 mg/día y mantener el esquema

D Suspender el etambutol de inmediato

E Cambiar la isoniazida por ciprofloxacino

Respuesta C. La orina anaranjada es un efecto benigno y esperado de la rifampicina. Las parestesias distales son neuropatía por isoniazida (déficit de piridoxina): se agrega vitamina B6 25–50 mg/día y se mantiene el tratamiento, ya que las pruebas hepáticas son normales.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 152

Un paciente de 42 años consulta por tos de un mes de evolución, sin expectoración. Su esposa está en tratamiento antituberculoso. Su examen físico muestra crépitos escasos bilaterales. Se realizaron baciloscopías de expectoración, que resultan negativas; quantiferón para tuberculosis, que resulta positivo; y radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia): La conducta más adecuada es:

A Iniciar profilaxis antituberculosa

B Solicitar reacción de cadena de polimerasa para tuberculosis en expectoración

C Iniciar tratamiento antibiótico antituberculoso

D Solicitar cultivo de Koch

E Solicitar PPD

Respuesta C. Es un paciente contacto estrecho y sintomático, que, además, ya tiene una prueba positiva para tuberculosis (el quatiferón). Por tanto, aunque tenga las baciloscopías negativas se debe iniciar el tratamiento y no es necesario pedir la PCR.

▶ VER CLASE 1.05.1.037 Tuberculosis pulmonar (fracaso de tratamiento)

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.3 · Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR

QUÉ HAY QUE SABER

- Fracaso de tratamiento: baciloscopías que persisten positivas o se repositivizan desde el 4.º mes de tratamiento, habiéndose negativizado (ej. negativas mes 2-3, positivas mes 4-5).
- Diferenciar de recaída (reaparece tras terminar el tratamiento y quedar curado) y de abandono; revisar adherencia y absorción.
- Confirmar con cultivo y test de susceptibilidad, más prueba molecular de resistencia (GeneXpert: rifampicina).
- Nunca agregar un solo fármaco a un esquema que falla ni prolongar el mismo esquema: genera multirresistencia.
- Seguimiento: derivar al especialista del Programa de Control de TBC para esquema secundario según antibiograma; mantener aislamiento respiratorio y estudio de contactos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 40 años en tratamiento antituberculoso supervisado, con buena adherencia documentada. Sus baciloscopías de control fueron negativas en el 2.º y 3.º mes, pero vuelven a ser positivas en el 4.º y 5.º mes. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar cultivo con estudio de susceptibilidad y prueba molecular de resistencia, y derivar al especialista del programa

B Prolongar el mismo esquema por 3 meses más

C Agregar levofloxacino al esquema actual

D Suspender el tratamiento y repetir las baciloscopías en un mes

E Cambiar a isoniazida en monoterapia

Respuesta A. Baciloscopías que se repositivizan después de negativizarse, desde el 4.º mes, definen fracaso de tratamiento y hacen sospechar resistencia. Se solicita cultivo con test de susceptibilidad y prueba molecular, y el caso lo maneja el especialista del Programa de Tuberculosis. Nunca se agrega un solo fármaco a un esquema que falla: genera más resistencia.

▶ VER CLASE 1.05.1.038 Nódulos pulmonares

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.1 · Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner

QUÉ HAY QUE SABER

- Nódulo pulmonar: opacidad única, redonda u oval, ≤30 mm, rodeada de pulmón normal, sin atelectasia ni adenopatías; >3 cm es masa (maligna hasta demostrar lo contrario).
- Primer paso: buscar imágenes previas; si es estable ≥2 años, es benigno. Sin previas, TAC de tórax de cortes finos.
- Benignidad: <6 mm, bordes lisos, calcificación central, concéntrica, difusa o en «popcorn» (hamartoma). Malignidad: >8-10 mm, espiculado, vidrio esmerilado parcial, calcio excéntrico, lóbulo superior, fumador >50 años.
- Conducta (Fleischner): <6 mm bajo riesgo sin control; 6-8 mm TAC a los 6-12 y 18-24 meses; >8 mm según probabilidad: intermedia PET-CT, alta biopsia o resección por VATS.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar los nódulos >8 mm, en crecimiento o sospechosos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 139

Paciente de 60 años, fumadora de 30 paquetes año, consulta por compromiso del estado general y baja de peso. Su examen físico es normal, se solicita radiografía de tórax que muestra lo siguiente: [radiografía: nódulo pulmonar solitario parahiliar derecho]. **La conducta más adecuada en este caso es:**

A Solicitar TAC de tórax
B Realizar punción transpleural
C Instalar tubo pleural con trampa de agua
D Realizar toracocentesis diagnóstica
E Realizar broncoscopía rígida

Respuesta A. La radiografía mostraba un nódulo pulmonar solitario parahiliar derecho. Sin radiografías previas que revisar, el primer examen es la TAC de tórax; la biopsia viene después. Si hubiese tenido radiografías previas, lo primero habría sido compararlas.

Situaciones clínicas de urgencia

14 códigos

▶ VER CLASE 1.05.2.001 **Asfixia por inmersión** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.5 · Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental

QUÉ HAY QUE SABER

- Ahogamiento: deterioro respiratorio por inmersión en líquido; la hipoxia es el mecanismo central, por aspiración o laringoespasmo. Más frecuente en niños pequeños (piscinas) y adolescentes varones (alcohol, ríos, mar).
- Rescate y RCP: la prioridad es oxigenar; iniciar con 5 ventilaciones de rescate y luego RCP estándar 30:2. No intentar drenar el agua de los pulmones ni hacer Heimlich (retrasa la ventilación y favorece el vómito).
- Inmovilización cervical solo si hay sospecha de trauma (zambullida en aguas poco profundas, caída de altura, signos de lesión).
- Hipotermia asociada: retirar ropa mojada, recalentar y prolongar la reanimación; no se declara muerte hasta recalentar al paciente.
- Oxígeno al 100%, gases arteriales y radiografía de tórax; observar al menos 6-8 horas aun asintomático, por riesgo de edema pulmonar no cardiogénico (SDRA) tardío; hospitalizar si hay síntomas, desaturación o crépitos.
- Prevención: supervisión continua de niños, cercado de piscinas, chaleco salvavidas y evitar alcohol al bañarse.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 6 años es rescatado de una piscina tras estar sumergido unos 3 minutos. No responde, no respira y no se palpa pulso. Hay 2 rescatadores capacitados. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Iniciar RCP comenzando con ventilaciones de rescate y continuar con compresiones, en relación 15:2
B Realizar la maniobra de Heimlich para expulsar el agua
C Colocar al niño boca abajo para drenar el agua
D Esperar la llegada de la ambulancia sin intervenir
E Realizar solo compresiones, sin ventilaciones

Respuesta A. En el ahogamiento el paro es por hipoxia, por lo que la ventilación es prioritaria: se inicia la RCP con ventilaciones de rescate y luego compresiones; con 2 rescatadores en niños la relación es 15:2. No se intenta drenar agua (Heimlich, posiciones), porque retrasa la RCP y aumenta el riesgo de aspiración.

▶ VER CLASE 1.05.2.002 **Aspiración de cuerpo extraño con asfixia** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.8 · Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Obstrucción completa por cuerpo extraño: atoro súbito comiendo o jugando, no puede toser, hablar ni llorar, con cianosis; signo universal de asfixia (manos al cuello). Típico niño de 1-3 años (frutos secos, uvas, salchicha) y adulto con carne.
- Si tose con fuerza (obstrucción parcial): no interferir, dejarlo toser y trasladar con oxígeno.
- Menor de 1 año: 5 golpes interescapulares seguidos de 5 compresiones torácicas, alternando. Heimlich contraindicado (lesión hepática o esplénica).
- Mayor de 1 año y adulto consciente: compresiones abdominales subdiafragmáticas (Heimlich) hasta expulsar el objeto o perder la conciencia; en embarazadas y obesos, compresiones torácicas.
- Si pierde la conciencia: activar emergencias e iniciar RCP con compresiones torácicas; mirar la boca antes de ventilar y retirar el objeto solo si es visible. Nunca barrido digital a ciegas.
- Tras la desobstrucción: evaluar complicaciones y descartar cuerpo extraño residual; broncoscopía si persisten síntomas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 50 años se atraganta con un trozo de carne en un restaurante. Se toma el cuello, no puede hablar ni toser y está cianótico. Tras varias compresiones abdominales, pierde la conciencia y cae al suelo. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Continuar las compresiones abdominales en el suelo

B Darle agua para desatascar

C Realizar barrido digital a ciegas

D Esperar a que recupere la conciencia

E Activar el sistema de emergencia e iniciar RCP con compresiones torácicas, revisando la boca antes de ventilar

Respuesta E. En la obstrucción completa de vía aérea con paciente consciente se hacen compresiones abdominales. Si pierde la conciencia, se activa la emergencia y se inicia RCP con compresiones torácicas, que también ayudan a expulsar el cuerpo extraño. Antes de ventilar se mira la boca y se retira el objeto solo si es visible; el barrido digital a ciegas está contraindicado.

▶ VER CLASE 1.05.2.003 Aspiración de cuerpo extraño sin asfixia

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.8 · Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Aspiración sin asfixia (obstrucción parcial): episodio súbito de tos y ahogo (síndrome de penetración) comiendo maní u otros, y luego el niño respira, tose en forma efectiva y llora.
- Conducta: no hacer maniobras de desobstrucción (pueden volverla completa); dejarlo toser en la posición que prefiera y trasladar con oxígeno.
- El objeto suele ir al bronquio derecho (más ancho y vertical): sibilancias o murmullo disminuido unilateral, atelectasia (lóbulo medio) o hiperinsuflación por efecto valvular.
- Radiografía en inspiración y espiración (atrapamiento aéreo); la mayoría de los objetos son radiolúcidos, una radiografía normal no descarta.
- Fase tardía: tos persistente o neumonía recurrente en el mismo sitio y sibilancias unilaterales que no ceden con salbutamol.
- Seguimiento: derivar para broncoscopía rígida bajo anestesia general, diagnóstica y terapéutica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 2 años, mientras comía maní, presentó un episodio súbito de tos intensa y ahogo. Ahora está consciente, rosado, tose en forma efectiva y llora. A la auscultación hay disminución del murmullo pulmonar y sibilancias en el hemitórax derecho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar la maniobra de Heimlich de inmediato

B No interferir con su tos y derivar para broncoscopía rígida

C Dar golpes interescapulares

D Realizar barrido digital

E Indicar salbutamol y control ambulatorio

Respuesta B. Si el niño respira y tose en forma efectiva, la obstrucción es parcial: no se hacen maniobras de desobstrucción, que podrían volverla completa. Se le deja toser, en la posición que prefiera, y se traslada con oxígeno. El síndrome de penetración con signos unilaterales obliga a broncoscopía rígida, diagnóstica y terapéutica. El salbutamol no resuelve un cuerpo extraño.

▶ VER CLASE 1.05.2.004 Crisis de asma bronquial

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 1.2 · Crisis Asmática en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Severidad: leve-moderada habla en oraciones, FC 100-120, FR <25, SatO2 90-95%, PEF 50-70%. Grave: habla en palabras, FC >120, FR >30, PEF <50%, musculatura accesoria (basta un criterio).
- Riesgo vital: tórax silente, bradicardia, confusión, cianosis, movimiento paradójico. PaCO2 «normal» (38-42) en crisis grave indica agotamiento inminente.
- Primera hora: oxígeno a SatO2 93-95%; salbutamol 4-8 puff con aerocámara c/20 min (+ ipratropio en moderada-grave); prednisona 40-50 mg VO precoz (hidrocortisona 200 mg EV si no tolera VO).
- Reevaluar a los 60 min con clínica y PEF: >70% y SatO2 >93% permite el alta; refractaria (PEF <50%): sulfato de magnesio 2 g EV en 20 min; sopor o PaCO2 >50: intubación (ketamina). No aminofilina ni antibióticos de rutina.
- Alta: prednisona 40 mg/día por 5-7 días sin descenso, iniciar o escalar corticoide inhalado, SABA de rescate, plan de acción escrito.
- Seguimiento: control en ≤7 días hábiles en APS para ajustar la terapia de mantención.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 179

Un paciente de 25 años, con antecedente de asma en tratamiento con fluticasona, un puff cada 12 horas, y salbutamol SOS, consulta por un cuadro de disnea que inició hace 48 horas en relación a un cuadro respiratorio alto y que ha ido empeorando, presentando actualmente disnea de mínimos esfuerzos que no ha respondido al uso de salbutamol. Al examen físico se observa taquipneico, con aumento del diámetro anteroposterior del tórax, frecuencia respiratoria de 35 por minuto, saturación de oxígeno 95% y frases con palabras entrecortadas. **¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para precisar la severidad del cuadro?**

A Radiografía de tórax
B Test de metacolina
C Flujo espiratorio máximo (PEF)
D Hemograma y VHS
E Gases en sangre venosa

Respuesta C. La severidad de la crisis se define con la clínica y el PEF, que objetiva la obstrucción y permite seguir la respuesta al tratamiento. Los gases útiles son los arteriales, no los venosos, y se piden en la crisis grave o sin respuesta. La metacolina provoca broncoespasmo: está contraindicada en crisis.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 22 años, asmática desde la infancia con tratamiento irregular, consulta en el SAPU por 4 horas de disnea intensa, tos y sibilancias. FR 32/min, FC 128/min, SatO2 89% ambiental. Habla solo con monosílabos entrecortados, tiraje intercostal y supraclavicular. PEF 160 L/min (38% del predicho). Sibilancias inspiratorias y espiratorias difusas. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Oxígeno, salbutamol con ipratropio cada 20 min y prednisona 40–50 mg VO
B Sulfato de magnesio 2 g EV como primera medida
C Aminofilina EV en carga y mantención
D Nebulizar con salbutamol y diferir el corticoide hasta evaluar respuesta
E Amoxicilina-ácido clavulánico y salbutamol a demanda

Respuesta A. Crisis grave: habla en monosílabos, FC > 120, FR > 30, musculatura accesoria y PEF < 50%. Conducta: oxígeno a SatO2 93–95%, salbutamol 4–8 puff + ipratropio con aerocámara cada 20 minutos en la primera hora y corticoide sistémico precoz. Reevaluar a los 60 minutos; el magnesio es el rescate si no responde.

▶ VER CLASE 1.05.2.005 Embolia pulmonar masiva

DX SOSPECHA · TX INICIAL · SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Cardiología 5.5 · Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP)
Respiratorio 4.4 · Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación

QUÉ HAY QUE SABER

- TEP masivo (alto riesgo): shock o PAS <90 mmHg por >15 min, síncope o paro, en paciente con factores de Virchow; mortalidad >15-30%.
- Clínica: disnea súbita intensa, hipoxemia, taquicardia, ingurgitación yugular por falla aguda del VD; ECG con taquicardia sinusal, S1Q3T3 o bloqueo de rama derecha.
- Paciente demasiado inestable para trasladar: ecocardiograma en la cama (VD dilatado e hipocinético); si se puede trasladar, angioTAC. El dímero D no tiene rol.
- Tratamiento inicial: oxígeno, heparina no fraccionada EV y trombólisis sistémica (alteplasa 100 mg EV en 2 h; en paro inminente 0,6 mg/kg en 15 min). Volumen cauteloso (el exceso agrava el VD); vasopresores si persiste hipotensión.
- Contraindicación absoluta de trombólisis (ACV hemorrágico, ACV isquémico <6 meses, sangrado activo, TEC reciente): embolectomía quirúrgica o por catéter.
- Seguimiento: derivar a UCI y luego anticoagulación por especialista.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 99

Un paciente masculino de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica, diabetes y dislipidemia, de larga data, en tratamiento oral. Desde hace 2 meses está en quimioterapia por cáncer de colon. Hoy presenta un síncope luego de levantarse de la cama y se asocia a disnea y dolor torácico. Su FC: 120x', PA: 90/50 mmHg, FR: 32x' y saturación de oxígeno: 93%. Su examen pulmonar es inespecífico. Se solicita electrocardiograma que muestra un bloqueo completo de rama derecha, con alteraciones inespecíficas de la repolarización. **¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio en este paciente?**

A Radiografía de tórax
B TAC de tórax
C Dímero D
D Ecocardiograma
E AngioTAC de tórax

Respuesta D. Cáncer en quimioterapia, síncope, taquicardia, hipotensión y bloqueo de rama derecha: TEP con compromiso hemodinámico. En el paciente inestable, el ecocardiograma en la cama demuestra la disfunción del ventrículo derecho sin trasladarlo; el angioTAC es de elección en el TEP estable.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 8

Un paciente de 60 años, fumador de 20 paquetes-año y con antecedente de trombosis venosa profunda hace 10 años, presenta un cuadro de disnea y malestar general de 7 días de evolución, que empeoró súbitamente hace unas horas, presentando un síncope con recuperación posterior. Al examen físico destaca presión arterial 70/40 mmHg, frecuencia cardíaca 150 lpm, frecuencia respiratoria 40 rpm y saturación de oxígeno de 86%. Se observa ingurgitación yugular y se constata que está desorientado. Se solicita un electrocardiograma, que muestra una taquicardia sinusal y se realiza un AngioTAC, que muestra defectos de llenado en ambas arterias pulmonares. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Trombólisis con tenecteplase
B Trombólisis con estreptoquinasa
C Heparina endovenosa
D Trombectomía abierta quirúrgica
E Trombectomía intraarterial con catéter

Respuesta A. TEP bilateral con PA 70/40, síncope y compromiso de conciencia: TEP de alto riesgo. El tratamiento de elección es la trombólisis sistémica con un trombolítico moderno. La heparina sola no basta y la trombectomía queda para cuando la trombólisis está contraindicada.

▶ VER CLASE 1.05.2.006 Enfermedad bronquial obstructiva crónica descompensada

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 1.5 · Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)

QUÉ HAY QUE SABER

- Exacerbación de EPOC: empeoramiento agudo de síntomas en <14 días; 75-80% infecciosa (H. influenzae, neumococo, Moraxella). Anthonisen: más disnea, más volumen y esputo purulento.
- Antibiótico si tiene los 3 criterios, o 2 incluyendo purulencia, o requiere ventilación: amoxicilina/clavulánico 875/125 mg c/12 h por 5-7 días (alternativas azitromicina o cefuroximo).
- Broncodilatación: salbutamol + ipratropio 4-8 puff con aerocámara c/20-30 min por 2 h, luego c/2-4 h; prednisona 40 mg/día por 5 días exactos, sin descenso.
- Oxígeno controlado: meta SatO2 88-92% con cánula 1-2 L/min o Venturi 24-28%; nunca reservorio a alto flujo (narcosis hipercápnica).
- Gases arteriales en la exacerbación moderada-grave: pH <7,35 con PaCO2 >45 indica VMNI (BiPAP); intubar si Glasgow <8, shock, vómitos o falla de la VMNI.
- Seguimiento completo: leve ambulatoria; al alta revisar técnica inhalatoria, escalar terapia de mantención (LAMA + LABA), vacunas, rehabilitación y control precoz.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 159

Un paciente de 67 años, con antecedente de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en tratamiento con broncodilatadores inhalados, evoluciona con aumento importante de su disnea basal, asociado a cianosis y angustia. El paciente está vigil y orientado y en su examen físico tiene FR: 35x', PA: 110/76 mmHg, FC: 110x' y al examen pulmonar se aprecia uso de musculatura accesoria, cianosis, aumento del diámetro anteroposterior y sibilancias y roncus intensos bilaterales. Se ingresa al servicio de urgencia, recibiendo antibióticos y nebulizaciones con broncodilatadores por una hora, sin mejoría clínica. Se solicitan gases arteriales, que resultan PaCO2: 62 mmHg, PaO2: 56 mmHg, pH: 7,29 y HCO3: 27 mEq/L. **La conducta más adecuada, a continuación, es:**

A Ventilación mecánica invasiva
B Aminofilina endovenosa
C Oxígeno por cánula nasal de alto flujo
D Ventilación no invasiva
E Bicarbonato de sodio endovenoso

Respuesta D. EPOC descompensado con acidosis respiratoria hipercápnica (pH 7,29, PaCO2 62) pese al tratamiento inicial. Está vigil y orientado, sin contraindicaciones: ventilación no invasiva. La invasiva se reserva para el compromiso de conciencia o el fracaso de la VMNI.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 70 años, EPOC por tabaquismo (40 paq/año), con 48 horas de aumento de disnea hasta mínimos esfuerzos, más volumen de esputo y secreciones verdes y espesas. FR 28 rpm, FC 102 lpm, PA 135/85 mmHg, SatO2 86% ambiental. Murmullo pulmonar disminuido, espiración prolongada, roncus y sibilancias difusas. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A O2 por mascarilla con reservorio, salbutamol y prednisona 40 mg por 14 días con descenso
B O2 por cánula con meta 88–92%, salbutamol + ipratropio, prednisona 40 mg por 5 días y amoxicilina/clavulánico
C O2 por cánula con meta 88–92%, salbutamol + ipratropio y prednisona 40 mg por 5 días, sin antibiótico
D Intubación orotraqueal inmediata y ventilación mecánica invasiva
E Aminofilina endovenosa y ciprofloxacino oral

Respuesta B. Tiene los 3 criterios de Anthonisen (disnea, volumen y purulencia): tipo 1, lleva antibiótico (amoxicilina/clavulánico 875/125 c/12 h por 5–7 días). Además: O2 controlado con meta 88–92%, SABA + SAMA y prednisona 40 mg por 5 días. Se piden gases para buscar acidosis e indicar VMNI si corresponde.

▶ VER CLASE 1.05.2.007 Hemoptisis moderada,severa y masiva

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.5 · Hemoptisis y Bronquiectasias

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemoptisis amenazante (masiva): >150-200 mL en 1 h o >500-600 mL en 24 h, o cualquier volumen que comprometa vía aérea, oxigenación o hemodinamia.
- Se muere por asfixia, no por shock: 90% proviene de arterias bronquiales (alta presión). Causas: bronquiectasias, TBC y secuelas, cáncer, aspergiloma.
- Primera medida: decúbito lateral sobre el lado que sangra (protege el pulmón sano), oxígeno, vía venosa, hemograma, coagulación y grupo; nunca Trendelenburg ni lado sano abajo.
- Si compromete la vía aérea: intubación con tubo grueso ≥8,0-8,5 mm para aspirar y permitir broncoscopía.
- Seguimiento: derivar urgente; angioTAC y broncoscopía localizan el sitio; embolización de arterias bronquiales (éxito >90%) y cirugía de resección si falla y es unilateral.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 48 años con tos diaria y expectoración purulenta abundante desde la juventud y neumonías a repetición. Consulta por 200 mL de sangre roja rutilante con coágulos en 30 minutos. FR 28/min, FC 110 lpm, SatO2 89 % ambiental. Abundantes estertores húmedos y gorgoteo en el hemitórax izquierdo. **¿Cuál es la primera medida?**

A Decúbito lateral izquierdo y oxígeno de alto flujo

B Decúbito lateral derecho y oxígeno de alto flujo

C Reposición con 2 litros de cristaloides

D TACAR de tórax urgente

E Cirugía de resección del lóbulo afectado

Respuesta A. Hemoptisis amenazante en bronquiectasias: la prioridad es evitar la asfixia. Decúbito lateral izquierdo (lado que sangra abajo) para proteger el pulmón derecho, oxígeno, reserva de hemoderivados y coordinar broncoscopía y embolización bronquial urgente.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 56 años con antecedente de secuela de tuberculosis pulmonar en el lóbulo superior derecho consulta por una hemoptisis masiva de aproximadamente 300 mL de sangre rutilante en 45 minutos. Presenta taquipnea, desaturación y gorgoteo bronquial audible. **¿Cuál es la primera medida postural y de soporte que se debe indicar de inmediato mientras se prepara la intubación y la fibrobroncoscopía?**

A Posición de Trendelenburg con cabeza baja a 30 grados

B Decúbito lateral derecho (lado sangrante hacia abajo) y oxigenoterapia a alto flujo

C Decúbito lateral izquierdo estricto para favorecer el drenaje

D Posición sentada ortopneica con compresión torácica bimanual

E Posición genupectoral

Respuesta B. La causa principal de muerte es la asfixia. El decúbito lateral hacia el lado de la lesión (aquí, el derecho) mantiene la sangre en el pulmón afectado y evita que atraviese la carina e inunde el pulmón sano.

▶ VER CLASE 1.05.2.008 Insuficiencia respiratoria aguda o crónica reagudizada que requiere ventilación mecánica

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.1 · Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

QUÉ HAY QUE SABER

- IRA o crónica reagudizada que requiere ventilación mecánica: Glasgow ≤8 o incapacidad de proteger la vía aérea, paro respiratorio o inminente, shock, agotamiento, hipoxemia refractaria o fracaso de la VMNI en 1-2 h.
- Diagnóstico gasométrico: PaO2 <60 mmHg; tipo 2 si PaCO2 >45. Fracaso de VMNI: empeoran pH y PaCO2, compromiso de conciencia, secreciones abundantes o vómitos.
- Manejo inicial: oxígeno, ventilación con bolsa-mascarilla (1 ventilación c/6 s si hay pulso), tratar causas reversibles (naloxona en opioides).
- Intubación con secuencia rápida; confirmar la posición con capnografía de onda continua y luego radiografía.
- Seguimiento: derivar a UCI para ventilación mecánica invasiva (en SDRA: Vt 6 mL/kg de peso ideal y plateau ≤30 cmH2O).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 95

Paciente de 55 años, con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica por tabaquismo, es derivado desde servicio de urgencia rural por aumento de su disnea basal, asociado a sensación febril y luego confusión, al ingreso en nuestro centro se solicitan gases arteriales que muestran pH 7.3, PaCO2 80, PaO2 86 con FiO2 al 100%. En su examen físico destaca sopor superficial, murmullo pulmonar disminuido en ambos campos pulmonares, con sibilancias difusas y crepitaciones en base pulmonar izquierda. **La medida más adecuada en este momento es:**

A Administrar hidrocortisona en bolo

B Nebulizar con salbutamol

C Administrar ceftriaxona

D Intubar e iniciar ventilación mecánica

E Disminuir el aporte de oxígeno a 24%

Respuesta D. EPOC exacerbado con hipercapnia severa (PaCO2 80) y encefalopatía hipercápnica (confusión, sopor). El compromiso de conciencia es criterio de escalar a intubación y ventilación mecánica invasiva: el paciente no protege su vía aérea y la VMNI no es segura. Bajar el oxígeno no revierte una narcosis ya instalada.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años es traído a urgencias tras ser encontrado en su casa con compromiso de conciencia, junto a blísteres vacíos de un opioide. Glasgow 7, FR 6 rpm, pupilas mióticas puntiformes, murmullo pulmonar normal. Gases con aire ambiental: pH 7,24, PaO2 58 mmHg, PaCO2 64 mmHg, HCO3 26 mEq/L. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Ventilación mecánica no invasiva con BiPAP

B Ventilar con bolsa-mascarilla y administrar naloxona endovenosa

C Oxígeno por cánula nasal a 2 L/min y observar

D Bicarbonato de sodio endovenoso para corregir el pH

E Solicitar angio-TAC de tórax por sospecha de TEP

Respuesta B. PAO2 = 150 − 64/0,8 = 70; gradiente = 70 − 58 = 12 mmHg (normal). IRA tipo 2 con gradiente normal: hipoventilación alveolar pura por opioides, con pulmón sano. Se ventila con bolsa-mascarilla y se revierte con naloxona. La VMNI no sirve en un paciente con Glasgow ≤ 8 que no protege su vía aérea.

▶ VER CLASE 1.05.2.009 Insuficiencia respiratoria aguda o crónica reagudizada, que no requiere ventilación mecánica

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.1 · Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia respiratoria: PaO2 <60 mmHg; tipo 1 hipoxémica (PaCO2 ≤45, gradiente A-a alto) o tipo 2 hipercápnica (PaCO2 >45; pH <7,35 si es aguda). Gradiente A-a = (150 − PaCO2/0,8) − PaO2.
- Mecanismos: alteración V/Q (NAC, EPOC, asma, TEP, el más frecuente), shunt (SDRA, edema; refractario al O2 100%), difusión, hipoventilación (opioides, neuromusculares; gradiente normal) y baja PiO2 (altura).
- Tipo 1: oxígeno a SatO2 92-96% con cánula 1-5 L/min (FiO2 24-40%), mascarilla o cánula nasal de alto flujo si PaFi <200.
- Retenedor de CO2 (EPOC): Venturi con FiO2 fija y meta 88-92%; el exceso de oxígeno empeora la hipercapnia.
- Acidosis hipercápnica (pH 7,25-7,35, PaCO2 >45) en EPOC exacerbado o edema pulmonar cardiogénico con paciente vigil: VMNI BiPAP (IPAP 10-15, EPAP 4-6 cmH2O) y reevaluar gases en 1-2 h.
- Tratar la causa (broncodilatadores, corticoides, antibióticos, diuréticos) y controlar con gases hasta la estabilización; al alta, controles en APS o con especialista según la causa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 72 años con EPOC grave presenta una exacerbación con disnea intensa, FR 30 por minuto y uso de musculatura accesoria. Está vigil y cooperadora. Gases arteriales: pH 7,28, PaCO2 68 mmHg, PaO2 50 mmHg, HCO3 31 mEq/L. **Además de broncodilatadores, corticoides y oxígeno controlado, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Intubación inmediata en todos los casos

B Oxígeno con mascarilla de reservorio al 100%

C Ventilación mecánica no invasiva (BiPAP)

D Bicarbonato endovenoso

E Sedación con benzodiacepinas

Respuesta C. La insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda sobre crónica con acidosis (pH bajo 7,35, PaCO2 sobre 45 mmHg) en una exacerbación de EPOC, con paciente vigil y cooperador, es la principal indicación de ventilación no invasiva: reduce intubación y mortalidad. El oxígeno se titula a 88-92%, porque al 100% empeora la hipercapnia. Se intuba si fracasa.

▶ VER CLASE 1.05.2.010 Intoxicación por monóxido de carbono

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.4 · Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo

QUÉ HAY QUE SABER

- Intoxicación por CO: brasero, calefón o incendio en espacio cerrado; varios afectados. Cefalea (lo más precoz), náuseas, mareo; en grave síncope, convulsiones, coma, arritmias o angina.
- El oxímetro de pulso marca falsamente normal: confirmar con carboxihemoglobina por co-oximetría (>3-5% no fumador, >10% fumador). El rojo cereza es raro y tardío.
- Tratamiento inmediato en todos: O2 al 100% con mascarilla de no recirculación a 15 L/min, ≥6 h (vida media de COHb: 320 min al aire → 80 min con O2 100% → 20-25 min hiperbárico).
- Cámara hiperbárica si COHb >25%, embarazada con COHb >15%, pérdida de conciencia o síncope, coma, convulsiones, déficit neurológico, isquemia miocárdica o pH <7,15.
- ECG y troponinas si hay síntomas cardíacos o factores de riesgo; evaluar a todos los expuestos y eliminar la fuente.
- Seguimiento: control por riesgo de síndrome neurológico tardío (semanas después: alteraciones cognitivas, parkinsonismo) y educación preventiva.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 10

Paciente de 27 años presenta cefalea, malestar general, disnea y opresión precordial, 3 horas después de estar expuesto a humo en un incendio en su casa. Frecuencia cardíaca 100 por minuto, presión arterial 130/85, frecuencia respiratoria 35, saturación de oxígeno 96 %. Sin cianosis, examen cardiopulmonar normal. **¿Qué examen confirma la sospecha diagnóstica?**

A Radiografía de tórax
B TAC de tórax
C Niveles de carboxihemoglobina
D Gases en sangre arterial
E Monitorización transcutánea de anhídrido carbónico

Respuesta C. El cuadro corresponde a intoxicación por monóxido de carbono. La saturación de pulso es falsamente normal porque no distingue oxihemoglobina de carboxihemoglobina, y los gases arteriales tampoco alteran la presión de oxígeno. El examen que confirma el diagnóstico es la medición directa de carboxihemoglobina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 41

Paciente de 25 años, encontrada inconsciente en el baño de su casa. Glasgow 15, presión arterial 110/60, frecuencia cardíaca 115, frecuencia respiratoria 12, saturación de oxígeno 98 %. Examen cardiopulmonar normal. Carboxihemoglobina de 20 por ciento. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Administrar oxígeno por naricera de alto flujo
B Solicitar una TAC de cerebro
C Realizar terapia hiperbárica
D Administrar broncodilatadores por vía inhalada
E Administrar oxígeno por mascarilla de no recirculación

Respuesta E. Confirmada la intoxicación por monóxido de carbono, el tratamiento inicial es oxígeno al cien por ciento con mascarilla de no recirculación, que acelera la eliminación del monóxido de la hemoglobina. La terapia hiperbárica se reserva para carboxihemoglobina sobre veinticinco por ciento o compromiso de conciencia importante, criterios que este caso no cumple.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 10

Un paciente de 27 años presenta cefalea, malestar general, disnea y sensación de opresión precordial, 3 horas después de haber estado expuesto a humo durante un incendio en su casa. Al examen físico registra frecuencia cardíaca 100 lpm, presión arterial 130/85 mmHg, frecuencia respiratoria 35 rpm y saturación de oxígeno de 96%. No presenta cianosis ni uso de musculatura accesoria, y su examen cardiopulmonar es normal. **¿Qué examen es el más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?**

A Radiografía de tórax
B TAC de tórax
C Niveles de carboxihemoglobina
D Gases en sangre arterial
E Monitorización transcutánea de niveles de anhídrido carbónico

Respuesta C. Exposición a humo con cefalea, disnea y opresión precordial y saturación normal: sospecha de intoxicación por CO. El oxímetro de pulso marca falsamente normal y los gases convencionales suelen ser normales. El examen de elección es la carboxihemoglobina por co-oximetría.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 41

Una paciente de 25 años fue encontrada inconsciente por su pareja en el baño de su casa, por lo que es llevada de inmediato al servicio de urgencias. Al examen físico, presenta escala de Glasgow: 15 puntos, tiene presión arterial: 110/60 mmHg, frecuencia cardíaca: 115 lpm, frecuencia respiratoria: 12 rpm y saturación de oxígeno: 98%. Su examen cardiopulmonar no muestra alteraciones. Se solicitan exámenes, que muestran glicemia: 98 mg/dl y carboxihemoglobina: 20%. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Administrar oxígeno por naricera de alto flujo
B Solicitar una TAC de cerebro
C Realizar terapia hiperbárica
D Administrar broncodilatadores por vía inhalada
E Administrar oxígeno por mascarilla de no recirculación

Respuesta E. Intoxicación por CO confirmada (COHb 20%) con saturación falsamente normal. La conducta inicial en todo paciente es O2 al 100% por mascarilla de no recirculación, que acelera la eliminación del CO. La pérdida de conciencia agrega indicación de oxígeno hiperbárico, pero eso viene después del oxígeno inmediato.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 144

Paciente encontrada en el baño, tenía carboxiHb de 12% tto de elección: **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A O2 mascarilla
B Cámara hiperbarica
C Ninguna de las anteriores es correcta
D Todas las anteriores son correctas
E No se dispone de información suficiente

Respuesta A. COHb 12%, bajo el corte de 25% y sin otra indicación descrita: el tratamiento es oxígeno al 100% por mascarilla con reservorio (normobárico). La cámara hiperbárica se reserva para sus indicaciones estrictas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 29 años, embarazada de 26 semanas, es traída desde su casa donde tenía un brasero encendido en el dormitorio. Refiere cefalea intensa, náuseas y mareo. Consciente, sin focalidad neurológica. PA 118/72 mmHg, FC 96 lpm, SatO2 99% con oxímetro de pulso. Co-oximetría: COHb 17%. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Alta con paracetamol, dado que la saturación es normal

B O2 por naricera a 3 L/min y control de COHb en 24 horas

C O2 al 100% con mascarilla con reservorio y derivar a oxígeno hiperbárico

D O2 al 100% normobárico solamente, porque la COHb es menor de 25%

E TAC de cerebro sin contraste antes de iniciar oxígeno

Respuesta C. Intoxicación por CO confirmada (COHb 17%) con saturación falsamente normal. En la embarazada el corte para oxígeno hiperbárico es COHb > 15%, porque la hemoglobina fetal concentra más CO. Se inicia O2 al 100% con reservorio de inmediato y se deriva a cámara hiperbárica.

▶ VER CLASE 1.05.2.011

Neumotórax hipertensivo

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.10 · Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante
Gastroenterología 6.4 · Trauma Abdominal y Torácico
Respiratorio 3.4 · Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático

QUÉ HAY QUE SABER

- Neumotórax a tensión: mecanismo de válvula; el aire entra y no sale, desplaza el mediastino, comprime las cavas y produce shock obstructivo y paro en AESP. Trauma o ventilación con presión positiva.
- Diagnóstico clínico, sin radiografía: shock, yugulares ingurgitadas, tráquea desviada al lado contrario, hemitórax timpánico con murmullo abolido.
- Descompresión inmediata con aguja 14-16 G en el 2.º EIC línea medioclavicular (alternativa ATLS: 5.º EIC línea axilar anterior), por el borde superior de la costilla inferior.
- Luego tubo pleural 28-32 Fr en el 5.º EIC entre líneas axilares anterior y media (triángulo de seguridad) a trampa de agua.
- Nunca intubar ni ventilar con presión positiva antes de descomprimir (precipita el paro).
- Diferenciar: hemotórax masivo (matidez, yugulares planas) y taponamiento (tríada de Beck, murmullo conservado). Seguimiento completo con control radiológico del tubo hasta reexpansión.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 27 años recibe una patada en el hemitórax izquierdo durante una riña. Llega con disnea marcada, pálido y sudoroso. Presión arterial de 78/44, frecuencia cardíaca de 128. Al examen, el murmullo pulmonar está abolido a izquierda, con timpanismo a la percusión, ingurgitación yugular y la tráquea desviada hacia la derecha. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Solicitar radiografía de tórax portátil antes de actuar

B Descomprimir con aguja gruesa en el segundo espacio intercostal izquierdo

C Realizar ventana pericárdica subxifoidea

D Iniciar transfusión de hemoderivados y observar

E Solicitar TAC de tórax con contraste

Respuesta B. Timpanismo, murmullo abolido, ingurgitación yugular y desviación traqueal contralateral son el cuadro clínico completo del neumotórax a tensión. El diagnóstico es clínico y la conducta es descomprimir de inmediato, sin esperar ninguna imagen.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 25 años, motorista, tras un choque presenta disnea intensa. FR 36 por minuto, SatO2 82 %, PA 75/40 mmHg, FC 140 por minuto, ingurgitación yugular, tráquea desviada a la derecha, murmullo pulmonar abolido e hipersonoridad en el hemitórax izquierdo. **¿Cuál es la conducta inmediata?**

A Radiografía de tórax urgente para confirmar

B TAC de tórax

C Intubación y ventilación a presión positiva antes de descomprimir

D Pericardiocentesis

E Descompresión inmediata del hemitórax izquierdo con aguja o toracostomía digital, seguida de tubo pleural

Respuesta E. El neumotórax a tensión es un diagnóstico clínico: shock, ingurgitación yugular, desviación traqueal contralateral, murmullo abolido e hipersonoridad. Se descomprime de inmediato, sin esperar imágenes, con aguja o toracostomía digital, y luego se instala tubo pleural. Ventilar a presión positiva antes de descomprimir lo agrava.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 25 años, motociclista, traído tras una caída a alta velocidad. Agitado, FR 36/min, SatO2 82 %, PA 70/40 mmHg, FC 140 lpm. Yugulares ingurgitadas, tráquea desviada a la izquierda, hemitórax derecho hiperinsuflado, timpánico y sin murmullo pulmonar. **¿Cuál es la conducta inmediata?**

A Radiografía de tórax portátil para confirmar el diagnóstico

B Intubación orotraqueal y ventilación con presión positiva antes de cualquier otra medida

C Pericardiocentesis subxifoidea

D Descompresión inmediata con aguja en el hemitórax derecho y luego tubo pleural

E Tubo pleural en el hemitórax izquierdo

Respuesta D. Shock obstructivo con yugulares ingurgitadas, tráquea desviada al lado contrario y hemitórax timpánico sin murmullo: neumotórax a tensión. Es un diagnóstico clínico y se descomprime de inmediato con aguja (2.º espacio intercostal en la línea medioclavicular, o 5.º en la axilar), seguido de tubo pleural. La radiografía no debe retrasarlo.

▶ VER CLASE 1.05.2.012 Paro cardiorespiratorio

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 1.2 · Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

QUÉ HAY QUE SABER

- Paro cardiorrespiratorio: paciente que no responde, sin respiración normal (o solo jadeos) y sin pulso palpable en ≤10 s; activar el sistema de emergencia y pedir el DEA.
- RCP de alta calidad: compresiones a 100-120/min, 5-6 cm de profundidad, permitir reexpansión completa, mínimas interrupciones; 30:2 sin vía aérea avanzada (con ella, 1 ventilación c/6 s continua).
- Ritmos desfibrilables (FV y TV sin pulso): descarga inmediata (bifásico 120-200 J), retomar compresiones 2 min; adrenalina 1 mg EV/IO tras la 2.ª descarga y c/3-5 min; amiodarona 300 mg tras la 3.ª (luego 150 mg).
- No desfibrilables (asistolia, AESP): RCP + adrenalina 1 mg lo antes posible y c/3-5 min; no desfibrilar.
- Buscar y tratar causas reversibles (5 H y 5 T): hipoxia, hipovolemia, hidrogeniones, hipo/hiperkalemia, hipotermia; neumotórax a tensión, taponamiento, tóxicos, trombosis coronaria y pulmonar.
- Tras recuperar la circulación: vía aérea, SatO2 92-98%, PAS >90, ECG de 12 derivaciones, control de temperatura; derivar a UCI.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 58 años colapsa en la sala de espera. No responde y no respira normalmente. Se activa el código de paro y se inicia RCP. Al conectar el monitor desfibrilador se observa fibrilación ventricular. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Administrar adrenalina 1 mg antes de cualquier descarga

B Verificar el pulso durante 1 minuto

C Intubar antes de desfibrilar

D Administrar amiodarona y esperar su efecto

E Desfibrilar de inmediato y reanudar las compresiones por 2 minutos sin verificar pulso

Respuesta E. La fibrilación ventricular es un ritmo desfibrilable: se desfibrila lo antes posible y se reanudan de inmediato las compresiones de alta calidad por 2 minutos antes de reevaluar el ritmo. La adrenalina se administra después de la segunda descarga y la amiodarona después de la tercera. Intubar o buscar pulso por mucho tiempo retrasa la descarga y reduce la sobrevida.

▶ VER CLASE 1.05.2.013 Traumatismo torácico grave

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 3.4 · Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático

QUÉ HAY QUE SABER

- Lesiones torácicas que matan primero (revisión primaria ATLS): neumotórax a tensión, neumotórax abierto, hemotórax masivo, tórax volante con contusión pulmonar y taponamiento cardíaco.
- Shock + yugulares ingurgitadas + timpanismo + tráquea desviada: neumotórax a tensión, descomprimir con aguja sin radiografía. Neumotórax abierto: parche fijado en 3 lados y luego tubo pleural.
- Hemotórax masivo (≥1.500 mL): shock con yugulares planas y matidez; tubo pleural 28-32 Fr + hemoderivados 1:1:1. Toracotomía si débito inicial ≥1.500 mL o >200 mL/h por 2-4 h.
- Tórax volante (≥3 costillas fracturadas en 2 segmentos): movimiento paradójico; la hipoxia es por la contusión pulmonar: oxígeno, analgesia potente y restricción de fluidos.
- Taponamiento: tríada de Beck con murmullo conservado; eco-FAST y pericardiocentesis o ventana pericárdica.
- Nunca ventilar con presión positiva sin descomprimir un neumotórax a tensión. Seguimiento: derivar a cirugía/UCI.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 30 años, conductora sin cinturón, ingresa tras colisión frontal. Pálida, sudorosa, confusa. PA 78/48 mmHg, FC 124/min, FR 28/min. Yugulares colapsadas. Dolor a la palpación de arcos costales izquierdos, matidez en los dos tercios inferiores del hemitórax izquierdo y ausencia de ruidos respiratorios. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inicial?**

A Neumotórax a tensión; punción con aguja en el 2.º espacio intercostal

B Taponamiento cardíaco; pericardiocentesis subxifoidea

C Hemotórax masivo; tubo pleural grueso y hemoderivados

D Contusión pulmonar; nebulización y analgesia oral

E Radiografía de tórax antes de decidir

Respuesta C. Shock con yugulares planas + matidez + murmullo abolido en el hemitórax traumatizado: hemotórax masivo. Conducta: tubo pleural 28–32 Fr y resucitación con hemoderivados 1:1:1. El neumotórax a tensión tendría timpanismo y yugulares ingurgitadas; el taponamiento, yugulares ingurgitadas y percusión normal.

▶ VER CLASE 1.05.2.014 **Traumatismo torácico simple** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.10 · Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante

QUÉ HAY QUE SABER

- Traumatismo torácico simple: contusión o fractura costal única sin neumotórax, hemotórax, tórax volante ni compromiso hemodinámico o respiratorio.
- Evaluación: signos vitales, SatO2, murmullo simétrico; radiografía de tórax para descartar neumotórax, hemotórax y fracturas múltiples.
- Tratamiento ambulatorio: analgesia efectiva (paracetamol, AINE, opioide débil si es necesario) y ejercicios respiratorios para toser y respirar profundo, evitando atelectasia y neumonía.
- El vendaje torácico compresivo está contraindicado: restringe la ventilación.
- Riesgo mayor en ancianos y fracturas múltiples (≥3), de 1.ª-2.ª costilla (trauma de alta energía) o bajas (lesión hepática o esplénica): observar u hospitalizar.
- Seguimiento completo: control ambulatorio y signos de alarma (disnea, fiebre, dolor que aumenta, hemoptisis); el dolor cede en 3-6 semanas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 45 años cae de su altura y se golpea el hemitórax derecho. Consulta por dolor al respirar. Está hemodinámicamente estable, con saturación de 97% y murmullo pulmonar simétrico. La radiografía muestra fractura no desplazada del 7° arco costal derecho, sin neumotórax ni hemotórax. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Instalación de tubo pleural

B Vendaje torácico compresivo

C Analgesia adecuada, ejercicios respiratorios y control ambulatorio con signos de alarma

D Fijación quirúrgica de la costilla

E Hospitalización en UCI

Respuesta C. Una fractura costal única sin complicaciones (neumotórax, hemotórax, tórax volante) en un paciente estable es un traumatismo torácico simple. Se maneja en forma ambulatoria con analgesia efectiva, que permite respirar profundo y toser, previniendo atelectasias y neumonía. El vendaje compresivo está contraindicado porque restringe la ventilación.

Conocimientos generales

5 códigos

▶ VER CLASE 1.05.3.001 **Contaminación ambiental**

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.4 · Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo

QUÉ HAY QUE SABER

- Contaminantes principales: material particulado fino (MP2,5) y grueso (MP10), ozono, NO2, SO2 y CO; en el centro-sur de Chile la principal fuente invernal es la combustión residencial de leña.
- Efectos: aumento de consultas y hospitalizaciones por IRA, crisis de asma y exacerbaciones de EPOC, mortalidad cardiovascular y respiratoria; mayor riesgo en niños, adultos mayores, embarazadas y enfermos crónicos.
- Gestión de episodios críticos (alerta, preemergencia, emergencia) según MP2,5: restricción vehicular, prohibición de calefactores a leña y de quemas, suspensión de actividad física al aire libre.
- Planes de descontaminación atmosférica: recambio de calefactores, leña seca certificada, aislación térmica de viviendas, transporte limpio.
- Consejería individual: evitar ejercicio al aire libre en episodios críticos, ventilar la vivienda, no fumar intradomiciliario, adherir a la terapia de mantención en asma/EPOC y vacunarse contra influenza y neumococo.
- Contaminación intradomiciliaria: humo de leña o biomasa (EPOC en mujeres no fumadoras), tabaco ambiental y CO por braseros y calefones mal ventilados.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Durante el invierno se decreta preemergencia ambiental en Santiago por niveles elevados de material particulado fino (MP2,5). La madre de un niño asmático de 8 años consulta qué medidas tomar. **¿Cuál es la recomendación más adecuada?**

A Evitar la actividad física intensa al aire libre, no usar leña ni braseros en el hogar y mantener el tratamiento controlador

B Realizar ejercicio intenso al aire libre para fortalecer los pulmones

C Suspender los inhaladores para evitar dependencia

D Ventilar la casa con las ventanas abiertas todo el día

E Calefaccionar con brasero

Respuesta A. El material particulado fino (MP2,5), de la combustión de leña, vehículos e industria, llega hasta los alvéolos y aumenta las exacerbaciones de asma y EPOC, las consultas respiratorias y los eventos cardiovasculares. En episodios críticos se evita el ejercicio intenso al aire libre, especialmente en niños, adultos mayores y enfermos crónicos, no se usa leña y se mantiene el tratamiento.

▶ VER CLASE 1.05.3.002 Prevención de daño pulmonar por inhalantes domésticos y laborales

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.3 · Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática

QUÉ HAY QUE SABER

- Exposiciones laborales: sílice cristalina (minería, canteras, arenado, construcción) causa silicosis; asbesto, asbestosis, placas pleurales, mesotelioma y cáncer; polvos orgánicos, neumonitis por hipersensibilidad; agentes irritantes o sensibilizantes, asma ocupacional.
- La silicosis no tiene tratamiento curativo y predispone a TBC y cáncer pulmonar: la prevención es la única medida eficaz.
- Jerarquía de control: eliminar o sustituir el agente, controles de ingeniería (técnicas húmedas, ventilación, encierro de procesos), controles administrativos y protección respiratoria certificada como última barrera.
- Vigilancia médica ocupacional con radiografía de tórax periódica (OIT) y espirometría; notificación como enfermedad profesional (Ley 16.744) y derivación a la mutualidad.
- Domésticas: evitar humo de leña o biomasa sin salida al exterior, braseros en dormitorios (CO) y tabaco intradomiciliario; ventilación adecuada al usar productos de limpieza y no mezclar cloro con amoníaco.
- Cesación tabáquica en todo trabajador expuesto: potencia el daño (asbesto + tabaco multiplica el riesgo de cáncer).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 50 años trabaja hace 20 años en una mina subterránea perforando roca sin protección respiratoria. Presenta disnea progresiva. La radiografía muestra múltiples nódulos pequeños en lóbulos superiores y adenopatías hiliares con calcificación 'en cáscara de huevo'. **¿Cuál es la medida más importante para prevenir esta enfermedad en los demás trabajadores?**

A Antibióticos profilácticos

B Corticoides inhalados preventivos

C Vacunación BCG anual

D Control de la exposición (técnicas húmedas y ventilación), protección respiratoria certificada y vigilancia médica con radiografía periódica

E Suplementos de vitamina D

Respuesta D. La silicosis es una neumoconiosis por inhalación de sílice cristalina, sin tratamiento curativo, que predispone a tuberculosis y cáncer pulmonar. Se previene controlando la exposición (técnicas húmedas, ventilación, encierro de procesos), con protección respiratoria adecuada y vigilancia ocupacional con radiografía periódica. Debe notificarse como enfermedad profesional.

▶ VER CLASE 1.05.3.003 Programa Nacional de Control de TBC

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 2.5 · Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- La TBC está en GES: diagnóstico, tratamiento y seguimiento gratuitos para todos los habitantes, independientemente de la previsión; notificación obligatoria.
- Pesquisa activa del sintomático respiratorio (tos con expectoración ≥2 semanas): GeneXpert MTB/RIF como examen inicial, baciloscopías y cultivo en todas las muestras. Grupos de riesgo: VIH, contactos, personas privadas de libertad, situación de calle, migrantes, diabéticos.
- Tratamiento directamente observado (TAES/DOTS) en el centro de salud: esquema primario 2 RHZE + 4 RH; asegura adherencia y previene resistencias.
- Estudio de contactos: anamnesis, examen y radiografía para descartar enfermedad activa; terapia preventiva con isoniazida en menores de 5 años o VIH sin esperar el PPD, y en adultos con infección latente.
- BCG al recién nacido (PNI): protege contra formas graves infantiles (meningitis y miliar).
- Seguimiento: baciloscopía mensual, manejo de reacciones adversas, derivación de fracasos, recaídas y multirresistencia al nivel secundario del programa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 21

Un paciente de 32 años, lleva un año conviviendo con pacientes bacilíferos, se encuentra asintomático y su radiografía de tórax no muestra alteraciones, se solicita un PPD que resulta en 23 mm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar tratamiento atibiótico con isoniazida, pirazinamida, rifampicina y etambutol por 6 meses

B Repetir PPD en un mes

C Dar de alta y control en caso de síntomas

D Solicitar reacción en cadena de polimerasa para mycobacterium tuberculosis en lavado bronquioloalveolar

E Indicar isoniazida por 6 meses

Respuesta E. Contacto asintomático, con radiografía normal (sin enfermedad activa) y PPD muy positivo: infección latente. Se indica terapia preventiva con isoniazida por 6 meses.

▶ VER CLASE 1.05.3.004 Tabaquismo: prevención, cesación y efectos nocivos para la salud

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 1.4 · Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

QUÉ HAY QUE SABER

- El tabaco causa EPOC, cáncer de pulmón y de otros órganos, cardiopatía coronaria, ACV, enfermedad arterial periférica y complicaciones del embarazo; el tabaquismo pasivo también daña (asma infantil, muerte súbita del lactante).
- Dejar de fumar es la única medida que normaliza la caída anual del VEF1 en la EPOC y reduce la mortalidad a cualquier edad.
- En cada control: preguntar, aconsejar, evaluar disposición, ayudar y seguir (5A); consejería breve aun si no quiere dejarlo (entrevista motivacional).
- Si está preparado: fijar fecha de cese + farmacoterapia (vareniclina, terapia de reemplazo de nicotina o bupropión); combinar consejería y fármacos multiplica la abstinencia. Alta dependencia: primer cigarrillo <30 min tras despertar.
- Reducir el número de cigarrillos no es cesación; el cigarrillo electrónico no es una terapia de cesación recomendada.
- Prevención poblacional: ambientes cerrados libres de humo, prohibición de publicidad, advertencias en envases, impuestos y prevención del inicio en adolescentes.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 62 años, fumador activo de 20 cigarrillos al día (40 paquetes-año), con EPOC GOLD 2 recién diagnosticada. Pregunta qué puede hacer para que su enfermedad avance más lento. **¿Cuál de las siguientes intervenciones ha demostrado enlentecer la caída anual del VEF1?**

A Tiotropio inhalado

B Corticoide inhalado en dosis alta

C Dejar de fumar

D Vacuna antineumocócica

E Rehabilitación pulmonar

Respuesta C. La cesación tabáquica es la única intervención que normaliza la velocidad de caída del VEF1 y, junto al oxígeno domiciliario en hipoxémicos, la que reduce mortalidad. Broncodilatadores y corticoides mejoran síntomas y exacerbaciones, pero no cambian la historia natural. Se debe ofrecer consejería más fármacos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 142

Un paciente fuma 5 a 7 cigarrillos al día y consulta porque quiere dejar de fumar. ¿Qué tratamiento es el más adecuado?

A Terapia cognitivo conductual

B Terapia de sustitución con nicotina

C Sertralina

D Bupropión

E Cigarrillo electrónico

Respuesta A. Fuma muy poco, como para que requiera burpopión o nicotina. Además la terapia cognitivo conductual siempre es la más efectiva para dejar de fumar.

▶ VER CLASE 1.05.3.005 Vacunación (tuberculosis, influenza, Coronavirus SARS-CoV-2 y neumococo)

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 2.5 · Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- BCG (PNI) al recién nacido: protege contra formas graves de TBC infantil (meningitis y miliar); protección limitada contra la TBC pulmonar del adulto. Vacuna viva: contraindicada en inmunodeficiencias; se posterga si el RN recibe isoniazida por madre bacilífera.
- Influenza: campaña anual previa al invierno para grupos de riesgo: adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y escolares de los primeros cursos, enfermos crónicos (asma, EPOC, cardiopatía, diabetes, inmunosuprimidos) y personal de salud.
- Neumococo: conjugada en lactantes según calendario PNI; en adultos mayores y en enfermos crónicos e inmunosuprimidos según PNI (asplenia, EPOC, cardiopatía, diabetes, VIH).
- SARS-CoV-2: refuerzos periódicos en grupos de riesgo (adultos mayores, inmunocomprometidos, embarazadas, enfermos crónicos y personal de salud).

- Indicar influenza y neumococo a todo paciente con asma, EPOC, bronquiectasias o insuficiencia respiratoria crónica; las vacunas inactivadas son seguras en inmunosuprimidos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una madre consulta en el control de su hijo de 1 mes por la vacuna BCG que este recibió antes del alta de la maternidad. **¿Cuál es el principal beneficio de la vacuna BCG?**

A Previene totalmente la tuberculosis pulmonar del adulto

B Protege contra las formas graves de tuberculosis en la infancia, como la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar

C Previene la infección por micobacterias atípicas

D Reemplaza el estudio y tratamiento de los contactos

E Protege contra la influenza

Respuesta B. La BCG, incluida en el PNI chileno, se administra al recién nacido. Su principal beneficio demostrado es la protección contra las formas graves y diseminadas de tuberculosis en niños (meningitis tuberculosa y miliar); su protección contra la tuberculosis pulmonar del adulto es variable y limitada. Por ser de bacterias vivas atenuadas, se contraindica en inmunodeficiencias.

Exámenes e imagenología

14 códigos

▶ VER CLASE 1.05.4.001 **Radiografía de tórax** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 2.1 · Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65

QUÉ HAY QUE SABER

- Técnica: PA y lateral de pie en inspiración; revisar identificación, penetración, rotación e inspiración antes de leer.
- Signo de la silueta: opacidad que borra el borde cardíaco derecho está en el lóbulo medio; el izquierdo, en la língula; el hemidiafragma, en el lóbulo inferior.
- Patrones: consolidación alveolar con broncograma aéreo (neumonía), intersticial, nódulo (≤3 cm) o masa, cavidad con nivel hidroaéreo (absceso), atelectasia (pérdida de volumen, desplazamiento de cisuras), hiperinsuflación con diafragmas aplanados (EPOC).
- Derrame: borra el ángulo costofrénico desde 150-200 mL, curva de Damoiseau; neumotórax: línea de pleura visceral sin trama periférica; a tensión es diagnóstico clínico, no radiológico.
- Insuficiencia cardíaca: índice cardiotorácico >0,5, redistribución de flujo a vértices, líneas B de Kerley, derrame bilateral; el SDRA tiene corazón normal e infiltrados periféricos.
- Indicaciones: confirmar NAC, estudio de tos crónica, hemoptisis, disnea, sospecha de TBC o cáncer; una radiografía normal no descarta TBC, cáncer ni TEP.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 66 años con 3 días de fiebre y tos productiva. En la radiografía de tórax posteroanterior se observa una opacidad de tipo alveolar con broncograma aéreo que borra el contorno del borde derecho de la silueta cardíaca; el hemidiafragma derecho se ve nítido. **¿Cuál es la localización más probable de la condensación?**

A Lóbulo medio

B Lóbulo superior derecho

C Segmento basal posterior del lóbulo inferior derecho

D Língula

E Segmento apical del lóbulo inferior derecho

Respuesta A. Signo de la silueta: una opacidad que borra un borde indica que está en contacto anatómico con él. El borde cardíaco derecho (aurícula derecha) limita con el lóbulo medio; si se borrara el hemidiafragma, sería el lóbulo inferior. Borrar el borde cardíaco izquierdo orienta a la língula.

▶ VER CLASE 1.05.4.002 **TAC de tórax** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.1 · Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner

QUÉ HAY QUE SABER

- TAC de tórax con contraste: caracteriza nódulos y masas, evalúa mediastino y adenopatías, etapifica el cáncer pulmonar (incluir abdomen superior) y guía biopsias.
- AngioTAC de arterias pulmonares: examen de elección para confirmar TEP en el paciente estable con Wells >4 o dímero D positivo (defecto de llenado arterial).
- TACAR sin contraste: EPID (patrón NIU con panal de abejas, NINE con vidrio esmerilado) y bronquiectasias (anillo de sello).
- Otras indicaciones: hemoptisis en fumador >40 años aun con radiografía normal, absceso o empiema tabicado, neumonía que no resuelve, trauma torácico, nódulo pulmonar (cortes finos).
- Interpretar el informe: nódulo con calcificación benigna o estable ≥2 años = benigno; espiculado, >8 mm o en crecimiento = estudio. Precauciones con contraste: alergia previa, insuficiencia renal y uso de metformina.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 165

Un paciente de 67 años, fumador de 40 paquetes/año presenta tos desde hace 4 meses, con expectoración mucosa y ocasionalmente hemoptoica. Además, ha presentado pérdida de 5 kilogramos peso. Al examen físico tiene FC: 72x', PA: 120/80 mmHg y se observa hipocratismo digital. Al examen pulmonar disminución del murmullo pulmonar en el lado derecho y crépitos en la misma zona. **¿Cuál es el examen diagnóstico más adecuado para comenzar el manejo?**

A PET-TC
B Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para tuberculosis y cultivo para micobacterias
C Fibrobroncoscopia con lavado bronquioalveolar
D TAC de tórax
E Resonancia magnética de tórax

Respuesta D. Fumador con tos, hemoptisis, baja de peso y acropaquia: sospecha de cáncer pulmonar. Se parte por la imagen (radiografía y TAC de tórax), que localiza la lesión y orienta la biopsia. El PET-CT se usa después, para etapificar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 58

Hombre de 60 años con tos de 3 meses de evolución y baja de peso. La radiografía de tórax muestra una masa hiliar derecha. **¿Cuál es el siguiente examen a solicitar?**

A Resonancia magnética de tórax
B Radiografía de tórax lateral
C TAC de tórax con contraste
D Cintigrafía ósea
E Ecografía de tórax

Respuesta C. Ante una masa pulmonar sospechosa en la radiografía, el siguiente paso es la TAC de tórax con contraste (idealmente incluyendo abdomen superior): caracteriza la lesión, evalúa adenopatías mediastínicas y metástasis suprarrenales o hepáticas, y guía la biopsia. La resonancia no es el estudio de elección del pulmón.

▶ VER CLASE 1.05.4.003 Ecografía pleural

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 3.1 · Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light

QUÉ HAY QUE SABER

- Más sensible que la radiografía: detecta derrames desde ~20 mL (la radiografía necesita 150-200 mL) y estima su volumen.
- Permite detectar tabiques, loculaciones o engrosamiento pleural, que sugieren derrame complicado o empiema y orientan a drenaje.
- Guía la toracocentesis y la instalación de tubos: reduce neumotórax y punciones fallidas; marca el sitio y la profundidad.
- Diferencia derrame de condensación o engrosamiento pleural; útil en pacientes críticos en la cama. La ausencia de deslizamiento pleural orienta a neumotórax.
- No reemplaza el análisis del líquido: no dice si es exudado, trasudado ni si está infectado.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 65 años hospitalizado por neumonía presenta en la radiografía un leve velamiento del seno costofrénico derecho. Se planea una toracocentesis diagnóstica. **¿Cuál es la principal utilidad de la ecografía pleural en este caso?**

A Medir el pH del líquido
B Confirmar y cuantificar el derrame, detectar tabiques y guiar la punción para reducir complicaciones
C Reemplazar el análisis del líquido pleural
D Diagnosticar cáncer pulmonar
E Ninguna, porque la radiografía es superior

Respuesta B. La ecografía pleural es más sensible que la radiografía para detectar derrames pequeños, permite estimar su volumen, detectar tabiques o loculaciones (sugerentes de derrame complicado) y elegir el sitio de punción. La toracocentesis guiada por ecografía reduce neumotórax y punciones fallidas. No reemplaza el estudio citoquímico y microbiológico del líquido.

▶ VER CLASE 1.05.4.004 Baciloscopia y cultivo de Koch de expectoración

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 2.5 · Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: todo sintomático respiratorio (tos con expectoración ≥2 semanas), sospecha clínica o radiológica de TBC y control del tratamiento.
- Baciloscopía (Ziehl-Neelsen o auramina): 2 muestras de expectoración (una inmediata y otra matinal); requiere >5.000 bacilos/mL, por lo que una negativa no descarta TBC. Cuantifica la baciliferia y el contagio.
- Cultivo de Koch (Löwenstein-Jensen o MGIT): estándar de oro, obligatorio en todas las muestras; único que permite identificar especie y antibiograma, pero tarda semanas. Un cultivo positivo confirma TBC aunque la baciloscopía sea negativa.
- GeneXpert MTB/RIF: PCR en <2 h que detecta el bacilo y resistencia a rifampicina; examen inicial de elección, sobre todo en VIH, niños y contactos de resistentes.

- Control del tratamiento: baciloscopía mensual; positividad desde el 4.º mes (o repositivización) sugiere fracaso: pedir cultivo y susceptibilidad y derivar. El cultivo corriente de expectoración no detecta M. tuberculosis.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 152

Un paciente de 42 años, fumador de 2,6 paquetes-año, presenta un cuadro de 3 meses de compromiso del estado general, astenia y baja de peso de 3 kilogramos, asociado a tos y expectoración mucopurulenta, que en ocasiones es hemoptoica. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra zonas de relleno alveolar en el lóbulo superior derecho. **¿Con qué examen(es) se debe proseguir el estudio?**

A Baciloscopías de expectoración y cultivo para micobacterias
B ELISA para VIH
C Biopsia pulmonar por videotoracoscopía
D Lavado broncoalveolar por broncoscopía
E TAC de tórax

Respuesta A. Tos productiva de más de 2 semanas, baja de peso y hemoptoicos con compromiso del lóbulo superior: sospecha de tuberculosis pulmonar. El estudio inicial es la baciloscopía seriada de expectoración más cultivo de Koch (hoy junto a prueba molecular). Los estudios invasivos se reservan si la expectoración no es diagnóstica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 49

Paciente de 34 años, consulta por cuadro de un mes de compromiso del estado general, tos persistente con expectoración mucopurulenta y en dos ocasiones hemoptóica. Al examen físico destaca sudoroso, frecuencia cardiaca de 60 por minuto, presión arterial de 120/70, examen cardiaco normal y pulmonar con murmullo presente, crepitaciones y sibilancias difusas mayores en ápice izquierdo. El examen más adecuado para el diagnóstico en este caso es:

A Baciloscopías seriadas
B Prueba cutánea de tuberculina
C Radiografía de tórax
D TAC de tórax multicorte
E Hemocultivo

Respuesta A. Diagnóstico: Baciloscopías seriadas (opción A). Sospechar una TBC. Se estudia con BK. La Rx hay que pedirla igual, pero BK es la respuesta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 99

Un paciente de 70 años, consulta por cuadro de 6 meses de evolución caracterizado por tos con expectoración mucosa que en ocasiones es purulenta y baja de peso, asocia- do a compromiso del estado general, sensación febril ocasional y fatigabilidad. Se le so- licita perfil hemático que muestra hematocrito de 32%, leucocitos 12.000/mm3. Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación: INSERTAR FOTO La conducta más adecuada para proseguir con el estudio es:

A Realizar broncoscopía
B Solicitar baciloscopías de expectoración con cultivo de Koch
C Solicitar TAC de tórax
D Solicitar angioTAC de tórax
E Solicitar cultivo de expectoración

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Solicitar baciloscopías de expectoración con cultivo de Koch (opción B). La sospecha es una tuberculosis, por el tiempo de evolución y por la clínica.

▶ VER CLASE 1.05.4.005 Espirometría

NIVEL **INTERPRETA Y EMPLEA**

DÓNDE SE ENSEÑA

Respiratorio 1.1 · Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar
Respiratorio 1.3 · Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES
Respiratorio 1.4 · Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

QUÉ HAY QUE SABER

- Prueba válida: al menos 3 maniobras reproducibles con esfuerzo máximo y espiración ≥6 segundos. Variables: VEF1, CVF y relación VEF1/CVF.
- Obstrucción: VEF1/CVF <0,70 (o bajo el límite inferior de normalidad); la severidad se gradúa por el VEF1 post-BD: ≥80% leve, 50-79% moderada, 30-49% grave, <30% muy grave.
- Prueba broncodilatadora (salbutamol 400 mcg, repetir a los 15 min): positiva si VEF1 o CVF aumentan ≥12% y ≥200 mL. Reversible orienta a asma; obstrucción fija (VEF1/CVF post-BD <0,70) en fumador confirma EPOC.
- Una espirometría normal no descarta asma (metacolina o variabilidad del PEF).
- Relación normal con CVF <80% sugiere restricción, que se confirma con pletismografía (CPT <80%); la espirometría sola no diagnostica fibrosis.
- Usos: diagnóstico y seguimiento de asma y EPOC (anual en programa ERA), evaluación preoperatoria, enfermedades ocupacionales.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 54 años, fumador de 25 paquetes-año, con disnea de esfuerzo progresiva. Espirometría basal: VEF1/CVF 0,58; VEF1 1,60 L (52% del predicho); CVF 2,76 L (78%). Tras 400 mcg de salbutamol: VEF1 1,72 L (aumento de 120 mL y 7,5%), VEF1/CVF 0,60. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Asma bronquial con respuesta broncodilatadora positiva

B EPOC con limitación moderada al flujo aéreo

C Restricción pulmonar confirmada por CVF bajo 80%

D EPOC con limitación muy grave al flujo aéreo

E Espirometría normal para la edad

Respuesta B. VEF1/CVF post-BD < 0,70 con cambio < 12% y < 200 mL: obstrucción no reversible, que en un fumador confirma EPOC. La severidad se gradúa por el VEF1 post-BD: 52% es moderada (50–79%). La CVF baja no confirma restricción.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 24 años con episodios de tos nocturna, sibilancias y disnea con el ejercicio desde hace 1 año. Espirometría: VEF1/CVF 0,68; VEF1 2,10 L (74 % del predicho). Tras 400 mcg de salbutamol: VEF1 2,46 L. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Espirometría normal

B Patrón restrictivo

C Obstrucción con respuesta broncodilatadora significativa, compatible con asma

D EPOC por VEF1/CVF menor de 0,70

E Obstrucción fija sin respuesta broncodilatadora

Respuesta C. Hay obstrucción (VEF1/CVF bajo 0,70) y el VEF1 sube 360 mL, un 17 %: supera el umbral de respuesta broncodilatadora significativa (12 % y 200 mL). En una joven con síntomas variables, confirma asma. En la EPOC la obstrucción persiste tras el broncodilatador.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años, fumador de 30 paquetes-año, con tos matinal y disnea de grandes esfuerzos. Espirometría basal: VEF1/CVF 0,66; VEF1 82 % del predicho. Tras 400 mcg de salbutamol: VEF1/CVF 0,74; VEF1 91 % del predicho. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A EPOC GOLD 1 confirmada

B Patrón restrictivo

C EPOC GOLD 2 por VEF1 basal bajo 85 %

D No se confirma EPOC: la relación VEF1/CVF posbroncodilatador es mayor de 0,70

E Asma grave

Respuesta D. El diagnóstico de EPOC exige obstrucción persistente: VEF1/CVF menor de 0,70 después del broncodilatador. Aquí la obstrucción revierte (0,74), así que no se confirma EPOC. Igual corresponde indicar cesación tabáquica y reevaluar, porque tiene síntomas y factor de riesgo.

▶ VER CLASE 1.05.4.006 Examen microbiológico de expectoración

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 2.1 · Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65

QUÉ HAY QUE SABER

- Gram y cultivo de expectoración: útiles en neumonía hospitalizada, grave o que no responde, bronquiectasias y exacerbaciones con riesgo de Pseudomonas; no se requiere en la NAC ambulatoria.
- Calidad de la muestra (Murray-Washington): útil si tiene >25 polimorfonucleares y <10 células epiteliales por campo de bajo aumento; muchas células epiteliales indica saliva: no cultivar, repetir.
- Gram: diplococos grampositivos lanceolados = neumococo; cocos grampositivos en racimos = S. aureus; cocobacilos gramnegativos = H. influenzae.
- Tomar antes de iniciar antibióticos; el cultivo orienta el ajuste según antibiograma (evitar tratar contaminantes de la flora oral).
- El cultivo corriente no detecta M. tuberculosis: para TBC se piden baciloscopía, cultivo de Koch y GeneXpert.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Se envía una muestra de expectoración de un paciente hospitalizado por neumonía para Gram y cultivo. El informe señala más de 25 células epiteliales y menos de 10 leucocitos polimorfonucleares por campo de bajo aumento. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Muestra de buena calidad: se debe tratar el germen que crezca

B Confirma neumonía neumocócica

C Muestra no representativa (saliva), no apta para cultivo: se debe repetir

D Indica tuberculosis

E Indica infección viral

Respuesta C. La calidad de la expectoración se evalúa con el criterio de Murray-Washington: una muestra útil tiene más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales por campo de bajo aumento. Muchas células epiteliales indican contaminación con saliva y flora orofaríngea, por lo que el cultivo no es interpretable y la muestra debe repetirse.

▶ VER CLASE 1.05.4.007 Citoquímico de líquido pleural

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Respiratorio 3.1 · Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light
Respiratorio 3.2 · Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

QUÉ HAY QUE SABER

- Criterios de Light (basta uno para exudado): proteínas pleura/suero >0,5, LDH pleura/suero >0,6, o LDH pleural >2/3 del límite superior sérico. Medir siempre en líquido y suero al mismo tiempo.
- Trasudado (IC, cirrosis, síndrome nefrótico): tratar la causa, sin estudio invasivo. Exudado (paraneumónico, cáncer, TBC, TEP): estudio de segunda línea.
- Segunda línea: recuento celular (neutrófilos = bacteriano; linfocitos >50% = TBC o cáncer), glucosa, pH (en jeringa de gases), ADA, citología.
- Paraneumónico complicado: pH <7,20 (mejor predictor), glucosa <40-60 mg/dL o LDH >1.000 U/L: tubo pleural.
- Linfocítico con ADA ≥40 U/L: TBC pleural; ADA bajo en fumador o mayor con baja de peso: cáncer (citología, biopsia). El TEP puede dar exudado o trasudado, a menudo serohemático.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 94

Paciente con derrame pleural unilateral. Se realiza toracocentesis. **¿Cuál es el examen del líquido pleural que permite clasificarlo como exudado o trasudado según los criterios de Light?**

A Proteínas y LDH en líquido pleural y suero
B Glucosa en líquido pleural
C ADA en líquido pleural
D pH del líquido pleural
E Recuento celular diferencial

Respuesta A. Criterios de Light: proteínas LP/suero > 0,5, LDH LP/suero > 0,6, LDH LP > 2/3 del límite normal. Uno o más criterios clasifican como exudado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 171

Un paciente de 40 años, consulta por disnea desde hace 2 semanas, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia matidez a la percusión y disminución del murmullo pulmonar en base izquierda. Se realiza radiografía que se muestra a continuación: **El examen más adecuado para seguir con el estudio es:**

A TAC
B AngioTAC
C Ecocardiografía
D Análisis citoquímico del líquido pleural
E Ecografía pleural

Respuesta D. Derrame pleural de causa no clara: se punciona y se analiza el líquido (criterios de Light y estudio de segunda línea).

▶ VER CLASE 1.05.4.008 Examen microbiológico de líquido pleural

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Respiratorio 3.2 · Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

QUÉ HAY QUE SABER

- Gram y cultivo (aerobios y anaerobios) del líquido pleural en todo derrame paraneumónico o exudado de causa no clara; idealmente antes de antibióticos.
- Gram o cultivo positivos (aunque el líquido se vea claro) definen empiema: indican tubo pleural además del antibiótico. Pus macroscópico también.
- El cultivo positivo orienta el antibiótico; los anaerobios son frecuentes y a menudo no crecen, por eso siempre se cubren.
- TBC pleural: baciloscopía del líquido positiva en <10% y cultivo de bajo rendimiento (paucibacilar); el diagnóstico se apoya en ADA ≥40 y biopsia pleural con granulomas.
- Un cultivo negativo no descarta derrame complicado si el pH o la glucosa son bajos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 55 años con neumonía basal derecha persiste febril al 4° día de tratamiento. La toracocentesis obtiene líquido turbio, no purulento, con pH 7,10, glucosa 35 mg/dL y LDH 1.500 U/L. El Gram del líquido muestra diplococos grampositivos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener los antibióticos sin otra intervención
B Suspender los antibióticos y observar
C Repetir la toracocentesis en 1 semana
D Instalar drenaje pleural (tubo pleural) además de los antibióticos
E Iniciar corticoides

Respuesta D. Un Gram o cultivo positivo del líquido pleural, o pH bajo 7,20, glucosa bajo 60 mg/dL o pus, definen un derrame paraneumónico complicado o empiema, que requiere drenaje pleural además de antibióticos. Si hay loculaciones que impiden el drenaje, se consideran fibrinolíticos intrapleurales o videotoracoscopía.

▶ VER CLASE 1.05.4.009 Flujo espiratorio máximo (PEF: Peak Expiratory Flow)

NIVEL REALIZA, INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Respiratorio 1.2 · Crisis Asmática en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Técnica: de pie, inspiración máxima, boquilla sellada, soplido corto, rápido y lo más fuerte posible; 3 intentos y se registra el mejor.
- Se expresa como % del mejor valor personal (o del teórico): en crisis asmática 50-70% moderada, <50% grave; objetiva la severidad junto con la clínica.
- Reevaluación a la hora del tratamiento de la crisis: PEF >70% con clínica estable y SatO2 >93% permite el alta; <50% tras tratamiento obliga a hospitalizar.
- Diagnóstico de asma: variabilidad diurna del PEF >10% demuestra limitación variable del flujo cuando la espirometría es normal.
- Monitoreo domiciliario en el plan de acción escrito: zonas verde (>80%), amarilla (50-80%) y roja (<50%) guían el uso de rescate y la consulta.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 26 años con crisis asmática en el SAPU. Ingresó con PEF de 45 % del predicho. Recibió oxígeno, 3 nebulizaciones de salbutamol con ipratropio y prednisona 40 mg oral. Una hora después: habla frases completas, FR 18/min, SatO2 96 % ambiental, sibilancias escasas y PEF 78 % del predicho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Hospitalizar en sala para tratamiento endovenoso

B Alta sin tratamiento, ya que el PEF es normal

C Sulfato de magnesio endovenoso antes del alta

D Mantener en observación 24 horas aunque esté estable

E Alta con prednisona por 5 a 7 días, corticoide inhalado y control precoz

Respuesta E. El PEF objetiva la respuesta: sobre 70 % del predicho a la hora, con clínica estable y SatO2 normal, permite el alta. Debe irse con corticoide oral 5 a 7 días, inicio o ajuste del corticoide inhalado, plan de acción y control precoz. Bajo 50 % tras tratamiento obliga a hospitalizar.

▶ VER CLASE 1.05.4.010 Gases en sangre arterial

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 3.4 · Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos
Respiratorio 1.2 · Crisis Asmática en el Adulto
Respiratorio 1.5 · Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)
Respiratorio 5.1 · Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Lectura sistemática: pH (acidemia <7,35, alcalemia >7,45), PaCO2 (respiratorio) y HCO3 (metabólico); verificar si la compensación es la esperada (Winter en acidosis metabólica; 0,7 × ΔHCO3 en alcalosis); fuera de lo esperado = trastorno mixto.
- Insuficiencia respiratoria: PaO2 <60 mmHg; tipo 2 si PaCO2 >45. Gradiente A-a = (150 − PaCO2/0,8) − PaO2: normal (5-15) en hipoventilación pura, elevado en enfermedad pulmonar.
- Aguda vs crónica: en la hipercapnia crónica el HCO3 sube y el pH queda casi normal; pH <7,35 con PaCO2 >45 en EPOC exacerbado indica VMNI.
- Crisis asmática: lo esperable es PaCO2 baja (hiperventilación); PaCO2 normal o alta con somnolencia indica agotamiento y paro inminente.
- PaFi (PaO2/FiO2): ≤300 con PEEP ≥5 define SDRA (≤200 moderado, ≤100 severo).
- Los gases venosos no sirven para oxigenación; la PaO2 convencional no detecta CO: pedir co-oximetría.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 40 años, sin enfermedad pulmonar, con 4 días de vómitos por gastroenteritis. Gases arteriales: pH 7,50, pCO2 48 mmHg, HCO3 36 mEq/L. Na 137 mEq/L, Cl 90 mEq/L, K 3,1 mEq/L. **¿Cuál es la interpretación más adecuada de los gases?**

A Acidosis respiratoria crónica compensada

B Alcalosis metabólica con acidosis respiratoria agregada

C Alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria agregada

D Alcalosis metabólica con compensación respiratoria adecuada

E Alcalosis respiratoria aguda

Respuesta D. pH alto y bicarbonato alto: alcalosis metabólica primaria. La pCO2 esperada es 0,7 × (36 − 24) + 40 = 48 mmHg (± 2). La medida es 48: compensación adecuada, trastorno simple. Una pCO2 mayor de 50 indicaría acidosis respiratoria agregada.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 19 años con crisis asmática de 6 horas. Tras 1 hora de salbutamol con ipratropio está somnoliento, con FR 30/min, uso de musculatura accesoria y murmullo pulmonar muy disminuido, casi sin sibilancias. Gases con oxígeno: pH 7,35, PaCO2 45 mmHg, PaO2 62 mmHg, HCO3 24 mEq/L. **¿Cuál es la interpretación más adecuada de los gases?**

A Signo de agotamiento respiratorio inminente; manejo en UCI y preparar intubación

B Gases tranquilizadores: la PaCO2 es normal

C Alcalosis respiratoria esperable en la crisis

D Acidosis metabólica por uso de salbutamol

E Hipoxemia leve que solo requiere más oxígeno

Respuesta A. En la crisis asmática el paciente hiperventila y la PaCO2 debe estar baja. Una PaCO2 normal o alta, con somnolencia y tórax silencioso, indica fatiga muscular y paro respiratorio inminente: crisis de riesgo vital que requiere UCI y preparar intubación.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 69 años con EPOC GOLD 3 consulta por exacerbación de 3 días. Somnoliento pero obedece órdenes, FR 30/min, SatO2 87 % con oxígeno por cánula a 2 L/min. Gases: pH 7,31, PaCO2 62 mmHg, PaO2 56 mmHg, HCO3 30 mEq/L. **¿Cuál es la interpretación de los gases y la conducta más adecuada?**

A Acidosis respiratoria crónica compensada; aumentar el oxígeno a 6 L/min

B Acidosis respiratoria crónica compensada; alta con broncodilatadores

C Acidosis metabólica; bicarbonato endovenoso

D Alcalosis metabólica; suspender los corticoides

E Acidosis respiratoria aguda sobre crónica; iniciar ventilación mecánica no invasiva

Respuesta E. El HCO3 alto indica retención crónica de CO2, pero el pH bajo 7,35 muestra que la compensación no alcanza: hay un componente agudo. Acidosis respiratoria aguda sobre crónica con pH entre 7,25 y 7,35 es la indicación clásica de ventilación no invasiva en la exacerbación de EPOC.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 35 años con síndrome de Guillain-Barré en progresión, con debilidad de extremidades y tos débil. Murmullo pulmonar normal, radiografía de tórax normal. Gases arteriales con aire ambiental (FiO2 21 %, a nivel del mar): pH 7,32, PaCO2 58 mmHg, PaO2 66 mmHg, HCO3 29 mEq/L. **¿Cuál es el mecanismo de la hipoxemia?**

A Alteración ventilación/perfusión por neumonía

B Disminución de la FiO2 por altura

C Cortocircuito intrapulmonar por SDRA

D Trastorno de difusión por fibrosis

E Hipoventilación alveolar pura, con gradiente alvéolo-arterial normal

Respuesta E. PAO2 = 150 − (58 / 0,8) ≈ 77 mmHg; gradiente A-a = 77 − 66 ≈ 11 mmHg, normal. Hipercapnia con gradiente normal y pulmón sano indica hipoventilación pura, aquí por debilidad neuromuscular. El tratamiento es ventilatorio; el oxígeno solo no corrige la causa.

▶ VER CLASE 1.05.4.011 PPD

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 2.1 · Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes

QUÉ HAY QUE SABER

- PPD (tuberculina): 0,1 mL intradérmico en el antebrazo; se lee la induración (no el eritema) en milímetros a las 48-72 horas.
- Positivo: ≥10 mm en inmunocompetentes; ≥5 mm en VIH, inmunosuprimidos (corticoides, biológicos) y contactos de riesgo.
- Indica infección por M. tuberculosis (o BCG), pero no distingue infección latente de enfermedad activa: siempre descartar TBC activa con clínica, radiografía y baciloscopías.
- Falsos negativos: inmunosupresión, desnutrición, TBC grave, lectura incorrecta; falsos positivos: BCG, micobacterias atípicas. Alternativa: IGRA (QuantiFERON).
- Uso: contactos adultos e inmunosuprimidos antes de biológicos; positivo sin enfermedad activa = terapia preventiva (isoniazida 6-9 meses). En contactos <5 años o VIH no se espera el PPD para iniciarla.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 35 años con VIH, en terapia antirretroviral y con CD4 de 350 células/mm³, es contacto intradomiciliario de un caso de tuberculosis pulmonar bacilífera. Está asintomático y su radiografía de tórax es normal. El PPD resulta de 7 mm. **¿Cuál es la interpretación y la conducta más adecuada?**

A PPD negativo: no requiere intervención

B El PPD no es interpretable en personas con VIH

C PPD dudoso: repetirlo en 1 año

D PPD positivo: iniciar tratamiento con 4 fármacos

E PPD positivo (≥5 mm en VIH): iniciar terapia preventiva de tuberculosis

Respuesta E. En personas con VIH u otra inmunosupresión, un PPD de 5 mm o más se considera positivo (en inmunocompetentes, 10 mm o más). Con radiografía normal y sin síntomas se descarta tuberculosis activa y se indica terapia preventiva (isoniacida o esquemas cortos con rifamicinas). El tratamiento con 4 fármacos se reserva para la enfermedad activa.

▶ VER CLASE 1.05.4.012 Prueba de provocación bronquial con fármacos

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 1.1 · Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: síntomas sugerentes de asma (tos, sibilancias, disnea nocturna o con gatillantes) con espirometría y prueba broncodilatadora normales.
- Demuestra hiperreactividad bronquial: positiva si el VEF1 cae ≥20% con dosis bajas de metacolina (PC20 baja); apoya el diagnóstico de asma.
- Alto valor predictivo negativo: una prueba negativa prácticamente descarta asma activa.
- Contraindicada en crisis asmática u obstrucción significativa (provoca broncoespasmo), IAM o ACV recientes y aneurisma; se realiza en laboratorio con broncodilatador disponible.
- No confundir con pruebas cutáneas: el prick demuestra sensibilización alérgica, no asma.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 163

Una paciente de 19 años presenta disnea, asociada a tos y ocasionalmente sibilancias. Refiere que sus síntomas suelen ser más frecuentes e intensos durante la noche. Ha notado aumento en la intensidad y frecuencia de estos síntomas, desde que adoptó un gato hace un mes. Sus signos vitales son normales, satura 98% a FiO2 ambientas y su examen cardiopulmonar es normal. Se solicita una radiografía de tórax, que resulta normal. Se realiza una espirometría basal y postbroncodilatador, que muestra parámetros dentro de la normalidad. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?**

A IgE sérica total

B TAC de tórax

C Prueba de provocación bronquial con metacolina

D Prueba cutánea para alérgenos inhalados

E Serología para Mycoplasma pneumoniae

Respuesta C. Síntomas compatibles con asma pero sin obstrucción en el examen ni en la espirometría: la variabilidad se demuestra con la provocación bronquial con metacolina (caída del VEF1 > 20%). El prick test demuestra atopia, no asma.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 163

Una paciente de 19 años presenta disnea asociada a tos y ocasionalmente sibilancias. Refiere que sus síntomas suelen ser más frecuentes e intensos durante la noche, y ha notado aumento de su intensidad y frecuencia desde que adoptó un gato hace un mes. Sus signos vitales son normales, satura 98% con FiO2 ambiental y su examen cardiopulmonar es normal. La radiografía de tórax es normal. Se realiza una espirometría basal y post broncodilatador que muestra parámetros dentro de la normalidad. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?**

A IgE sérica total

B TAC de tórax

C Prueba de provocación bronquial con metacolina

D Prueba cutánea para alérgenos inhalados

E Serología para Mycoplasma pneumoniae

Respuesta C. Ante síntomas sugerentes de asma con espirometría normal, se busca hiperreactividad bronquial con la prueba de provocación con metacolina: una caída del VEF1 de 20% con dosis bajas apoya el asma, y una prueba negativa prácticamente lo descarta. El prick test demuestra sensibilización al gato, pero no confirma asma.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 24

Paciente de 20 años, con antecedente de rinitis alérgica y usuaria de anticonceptivos orales, con historia de disnea y tos seca al realizar ejercicios, no asociado a otros síntomas. Actualmente asintomática y su examen físico es normal. El examen de elección para el diagnóstico de esta paciente es:

A Test de esfuerzo
B Test de metacolina
C Prick test
D Espirometría
E PEF

Respuesta B. Por ser un asma sin clínica actual, no servirá ni el PEF ni la espirometría. Esta pregunta también es muy discutible, ya que el diagnóstico de asma es clínico y los demás exámenes solo son de apoyo diagnóstico. Además en la mayoría de los libros, guías y recomendaciones se prefiere hacer espirometría y solo solicitar las demás pruebas ante la duda diagnóstica. Sin embargo, el eunacom ha preguntado esto varias veces y ante un examen totalmente normal y clínica muy leve, la espirometría resulta...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 64

Una paciente de 21 años presenta rinorrea, congestión nasal, disnea, tos, con expectoración mucosa y sibilancias, que aparecen luego de realizar ejercicio y durante las infecciones respiratorias, siendo mayores en primavera. Su examen físico tiene frecuencia respiratoria 12x', frecuencia cardíaca 73x', PA: 120/70 mmHg, examen cardiopulmonar normal. Se solicitar un PEF, que resulta 580 L/min, que equivale al 100% del valor esperado. ¿Cuál de los siguientes es el examen más adecuado para proseguir con el estudio en esta paciente?

A Prick test
B TAC de tórax
C Espirometría basal y postbroncodilatador
D Prueba de eosinófilos nasales
E Prueba de provocación bronquial

Respuesta E. Aunque el diagnóstico de asma es principalmente clínico, tanto la espirometría como la prueba de provocación con metacolina son útiles para apoyar el diagnóstico. La espirometría es de elección en los pacientes con obstrucción clínica y la provocación con metacolina es de elección en los pacientes sin nada de obstrucción basal, como en esta paciente.

▶ VER CLASE `1.05.4.013` **Pruebas cutáneas de alergia** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.9 · Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales

QUÉ HAY QUE SABER

- Prick test: detecta sensibilización mediada por IgE a aeroalérgenos (ácaros, pólenes, epitelios, hongos) o alimentos; se lee la roncha a los 15-20 minutos.
- Requiere control positivo (histamina) y negativo (suero) para validar la respuesta y descartar dermografismo.
- Suspender antihistamínicos orales 5-7 días antes (también tricíclicos) por falsos negativos; los corticoides intranasales no interfieren.
- Un positivo indica sensibilización, no enfermedad: debe correlacionarse con la clínica. Alternativa si no se puede suspender antihistamínicos o hay dermatitis extensa: IgE específica sérica.
- Indicaciones: rinitis o asma persistente para identificar alérgenos y orientar el control ambiental (fundas antiácaros, lavado con agua caliente) o la inmunoterapia.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 28 años con rinorrea acuosa, estornudos y prurito nasal estacionales será sometido a un prick test para identificar alérgenos. Usa loratadina diaria y mometasona intranasal. **¿Cuál es la indicación más adecuada antes del examen?**

A Suspender la loratadina al menos 5 a 7 días antes del test
B Aumentar la dosis de loratadina el día del examen
C Suspender el corticoide intranasal 1 mes antes
D Realizar el test durante una anafilaxia
E No requiere preparación

Respuesta A. Los antihistamínicos orales inhiben la roncha y causan falsos negativos, por lo que se suspenden 5 a 7 días antes del prick test. El control positivo con histamina verifica que la piel responda y el control negativo con suero descarta dermografismo. Los corticoides intranasales no alteran la prueba. Un positivo indica sensibilización, que debe correlacionarse con la clínica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 126

Un hombre de 30 años, con rinorrea frecuente, se realiza prueba cutánea (prick test), que muestra reacción de 5mm a pólenes y de 0 mm al control histamina. ¿Cuál es la interpretación más adecuada de esta prueba?

A Es alérgico

B Está sensibilizado a pólenes

C Tiene rinitis vasomotora

D Tiene sinusitis crónica

E Anergia cutánea

Respuesta B. En mi opinión, es una pregunta con error, ya que el control positivo (con histamina) resulta 0 mm, lo que habitualmente significa que está usando antihistamínicos y el examen no sirve, por la anergia cutánea farmacológica, sin embargo, también resulta negativo para todo lo demás. En cambio, en este caso, resultó positivo para pólenes (>3 mm), lo que es imposible según lo anterior, pero da cuenta que está sensibilizado para pólenes. Por eso, dejaremos como respuesta correcta la B. Lo más...

▶ VER CLASE **1.05.4.014** **Saturometría arterial** NIVEL REALIZA, INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.4 · Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo

QUÉ HAY QUE SABER

- Oxímetro de pulso: SatO2 normal ≥95% a nivel del mar; SatO2 90% equivale aproximadamente a PaO2 60 mmHg (inflexión de la curva).
- Metas: 92-96% en la mayoría; 88-92% en retenedores de CO2 (EPOC); 93-95% en crisis asmática (≥95% en embarazadas o cardiópatas).
- Falsamente normal en intoxicación por CO (no distingue carboxihemoglobina) y en metahemoglobinemia; pedir co-oximetría.
- Lecturas poco confiables con hipoperfusión o shock, hipotermia, movimiento, uñas pintadas, anemia severa; verificar la curva de pulso.
- No mide ventilación: puede ser normal con hipercapnia grave (sobre todo con oxígeno), por eso en IR se complementa con gases arteriales.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una familia de 4 personas consulta en invierno por cefalea, náuseas y mareos que comenzaron en la noche, en una casa calefaccionada con brasero. Una mujer de 40 años está somnolienta y tiene saturometría de pulso de 99% ambiental. **¿Cuál es la interpretación más adecuada de la saturometría?**

A Puede estar falsamente normal, porque el oxímetro convencional no distingue carboxihemoglobina de oxihemoglobina: se debe medir carboxihemoglobina

B Descarta una intoxicación por monóxido de carbono

C Indica que no requiere oxígeno

D Indica hiperventilación

E Indica anemia

Respuesta A. El oxímetro de pulso convencional usa 2 longitudes de onda y lee la carboxihemoglobina como oxihemoglobina, por lo que la saturación aparece falsamente normal en la intoxicación por CO. Se mide carboxihemoglobina por cooximetría en gases arteriales o venosos y se inicia de inmediato oxígeno al 100% con mascarilla de alto flujo, sin esperar el resultado.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 12 códigos

▶ VER CLASE **1.05.5.001** **Aspiración traqueal** NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.1 · Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: secreciones visibles o audibles (roncus, gorgoteo), desaturación o aumento de presiones en paciente intubado o traqueostomizado, o que no puede toser eficazmente; obtener muestras para cultivo.
- Preparación: técnica aséptica (guantes estériles, sonda estéril), preoxigenar con O2 100% por 30-60 s, monitorizar SatO2 y frecuencia cardíaca.
- Sonda de calibre no mayor que la mitad del diámetro interno del tubo; introducir sin aspirar hasta encontrar resistencia, retirar 1 cm y aspirar mientras se retira con rotación.
- Cada aspiración ≤10-15 segundos con presión moderada (aprox. 80-150 mmHg en adultos); reoxigenar entre pasadas y no instilar suero de rutina.
- Complicaciones: hipoxemia, bradicardia vagal y arritmias, broncoespasmo, trauma de mucosa y sangrado, atelectasia e infección; suspender si hay desaturación o bradicardia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 70 años, intubado en UCI, presenta secreciones abundantes, roncus y caída de la saturación a 89%. Se decide aspirar las secreciones por el tubo endotraqueal. **¿Cuál es la técnica más adecuada?**

A Aspirar en forma continua durante 1 minuto mientras se introduce la sonda

B Preoxigenar, usar técnica estéril y aspirar en forma intermitente al retirar la sonda, por no más de 10 a 15 segundos

C Instilar suero fisiológico de rutina antes de cada aspiración

D Aspirar cada 1 hora aunque no haya secreciones

E Usar la misma sonda para aspirar primero la boca y luego la tráquea

Respuesta B. La aspiración traqueal se realiza solo cuando es necesaria, con técnica estéril, preoxigenación y sonda de calibre adecuado, aplicando aspiración solo al retirar y por no más de 10 a 15 segundos, para evitar hipoxemia, bradicardia y trauma de mucosa. No se recomienda instilar suero de rutina, y la tráquea se aspira antes que la boca.

▶ VER CLASE 1.05.5.002 Biopsia pleural

NIVEL **DERIVAR A ESPECIALISTA**

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 3.5 · Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: exudado linfocítico sin diagnóstico tras el análisis del líquido (sospecha de TBC o cáncer), especialmente con citologías negativas o engrosamiento pleural nodular.
- Biopsia percutánea con aguja: rinde >80% en TBC pleural (granulomas caseificantes) cuando el ADA es limítrofe o dudoso.
- Toracoscopía o videotoracoscopía (VATS): de elección ante sospecha de neoplasia con 2 citologías negativas o mesotelioma (asbesto); rendimiento >90% y permite pleurodesis en el mismo acto.
- La biopsia es pleural, no pulmonar: no repetir citologías indefinidamente ni iniciar tratamiento antituberculoso empírico con ADA bajo.
- Nivel del médico general: plantear la indicación y derivar a broncopulmonar o cirugía de tórax con radiografía, TAC y estudio del líquido.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 68 años, exfumadora, con baja de peso y derrame pleural derecho recidivante. Dos toracocentesis muestran exudado linfocitario con ADA 18 U/L y citología negativa para células neoplásicas en ambas muestras. TAC de tórax: engrosamiento pleural nodular derecho. **¿Cuál es el procedimiento más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A Toracoscopía (pleuroscopía) con biopsia pleural dirigida

B Pleurodesis con talco sin diagnóstico histológico

C Tercera citología del líquido pleural

D Tratamiento antituberculoso empírico

E Marcadores tumorales en sangre

Respuesta A. Ante sospecha de derrame neoplásico con 2 citologías negativas, una tercera rinde poco. La toracoscopía permite ver la pleura y biopsiar los nódulos bajo visión directa, con rendimiento superior a 90 % para neoplasia, y en el mismo acto hacer pleurodesis. El ADA bajo hace improbable la tuberculosis.

▶ VER CLASE 1.05.5.003 Cricoidostomía

NIVEL **REALIZAR**

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: escenario «no puedo intubar, no puedo oxigenar» (trauma maxilofacial grave, edema de glotis, obstrucción supraglótica) cuando fallan la intubación y la ventilación con bolsa-mascarilla o dispositivo supraglótico.
- Reparos: membrana cricotiroidea, entre el cartílago tiroides y el cricoides; vía rápida y con pocas estructuras vasculares.
- Técnica quirúrgica: hiperextensión si no hay lesión cervical, fijar la laringe, incisión de piel y de la membrana, dilatar e insertar tubo con balón de pequeño calibre (6,0); confirmar con capnografía.
- Menores de 12 años: cricotiroidotomía por punción con aguja 12-14 G y ventilación en jet (la quirúrgica arriesga estenosis subglótica).
- Es temporal: convertir a traqueostomía. Contraindicaciones relativas: fractura o sección laríngea y edad <12 años (quirúrgica).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 30 años ingresa tras un accidente de tránsito con trauma facial grave, fractura mandibular y sangrado orofaríngeo masivo. Está desaturando a 75%, no se logra ventilar con bolsa-mascarilla y fracasan 2 intentos de intubación orotraqueal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Nuevo intento de intubación con un laringoscopio de otro tamaño

B Traqueostomía reglada en pabellón

C Cricotiroidotomía quirúrgica de urgencia

D Intubación nasotraqueal a ciegas

E Ventilación no invasiva

Respuesta C. La situación de 'no puedo intubar, no puedo oxigenar' indica una vía aérea quirúrgica de urgencia: cricotiroidotomía a través de la membrana cricotiroidea, rápida y con pocas estructuras vasculares. La traqueostomía es más lenta y compleja en urgencia, y la intubación nasotraqueal se evita en trauma facial grave. En menores de 12 años se prefiere la cricotiroidotomía por punción.

▶ VER CLASE 1.05.5.004 Drenaje pleural

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA

Respiratorio 3.2 · Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural
Respiratorio 3.4 · Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: neumotórax grande, secundario o tras descompresión de uno a tensión; hemotórax; derrame paraneumónico complicado o empiema; quilotórax; derrame maligno para pleurodesis.
- Sitio: triángulo de seguridad, 4.º-5.º EIC entre líneas axilares anterior y media, sobre el borde superior de la costilla inferior (el paquete vasculonervioso corre por el borde inferior).
- Calibre: 24-28 Fr en empiema, 28-32 Fr en hemotórax; conexión a trampa de agua (succión suave −10 a −20 cmH2O si se requiere).
- En hemotórax, toracotomía si el débito inicial es ≥1.500 mL o >200 mL/h por 2-4 h; nunca pinzar un tubo que sangra.
- Nivel del médico general: indicar y derivar a especialista; reconocer complicaciones (mala posición, lesión de hígado/bazo si es bajo, edema de reexpansión, infección).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años con empiema pleural izquierdo confirmado. Se decide instalar un tubo de drenaje pleural en decúbito supino con el brazo en abducción. **¿Cuál es el sitio de inserción recomendado?**

A 2.º espacio intercostal, línea medioclavicular

B 8.º espacio intercostal, línea escapular

C 4.º o 5.º espacio intercostal, entre las líneas axilares anterior y media (triángulo de seguridad)

D Región subxifoidea

E Borde inferior de la 5.ª costilla, línea axilar posterior

Respuesta C. El tubo se instala en el triángulo de seguridad: borde lateral del pectoral mayor, borde anterior del dorsal ancho y línea del pezón (4.º a 5.º espacio), sobre el borde superior de la costilla inferior. Evita la arteria mamaria, el diafragma y las vísceras abdominales, y se conecta a trampa de agua.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Paciente traumatizado ingresa con un hemotórax masivo derecho. Se instala un tubo de drenaje torácico 32 Fr, con salida inmediata de 1.700 mL de sangre fresca. Pese a la reposición con fluidos y glóbulos rojos, en las 2 horas siguientes el débito es de 250 mL/hora continuo. **¿Cuál es la indicación de manejo definitivo?**

A Instalar un segundo tubo pleural en el mismo hemitórax

B Pinzar el tubo para favorecer el coágulo intratorácico

C Toracotomía de urgencia en pabellón

D Embolización selectiva por angiografía en 24 horas

E Ácido tranexámico y observación en sala

Respuesta C. Cumple los dos criterios de toracotomía de urgencia: drenaje inicial ≥ 1.500 mL (1.700 mL) y débito > 200 mL/h por 2 a 4 horas (250 mL/h). Pinzar el tubo provocaría un hemotórax a tensión.

▶ VER CLASE 1.05.5.005 Fibrobroncoscopia

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA

Respiratorio 2.4 · Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones diagnósticas: sospecha de cáncer central (biopsia), hemoptisis en mayor de 40 años o fumador aun con radiografía normal, atelectasia persistente, neumonía que no resuelve o recurrente en el mismo sitio.
- Absceso pulmonar en mayor de 50 años, fumador o desdentado sin factores de aspiración: descartar carcinoma obstructivo o cuerpo extraño.
- Lavado broncoalveolar en inmunosuprimidos (Pneumocystis, hongos) y en sospecha de TBC con baciloscopías y GeneXpert negativos.

- Terapéutica: aspiración de secreciones o tapones mucosos, localización y control de hemoptisis; en cuerpo extraño (sobre todo en niños) se usa la broncoscopía rígida.
- Nivel del médico general: plantear la indicación y derivar a broncopulmonar; idealmente con TAC previa para orientar el sitio.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 67 años, fumador de 50 paquetes-año, desdentado total, sin alcoholismo ni trastornos de conciencia ni de deglución. Consulta por 4 semanas de fiebre y tos purulenta. Radiografía: cavidad de 5 cm con nivel hidroaéreo en el lóbulo superior derecho. Baciloscopías negativas. **Además de iniciar antibióticos, ¿cuál es el estudio más adecuado?**

A Ninguno: es un absceso por aspiración típico

B Fibrobroncoscopía para descartar una neoplasia endobronquial obstructiva

C Cintigrafía pulmonar

D Ecocardiograma transesofágico

E Prueba de tuberculina

Respuesta B. Un absceso sin factores de aspiración, en un desdentado (sin dientes no hay flora anaerobia gingival abundante), en un gran fumador mayor, obliga a descartar un cáncer bronquial que obstruye y abscede el pulmón distal, o un carcinoma cavitado. La fibrobroncoscopía visualiza la vía aérea y permite biopsia.

▶ VER CLASE 1.05.5.006 Inhalación de aerosoles presurizados

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 1.3 · Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Técnica con inhalador presurizado: retirar la tapa, agitar, exhalar fuera del inhalador, disparar 1 puff al inicio de una inspiración lenta y profunda, mantener apnea ~10 segundos; esperar 30-60 s entre puffs.
- Aerocámara (espaciador): recomendada en niños, adultos mayores, crisis y en quien no coordina; 1 puff a la vez y 5-6 respiraciones por puff (con mascarilla en lactantes y preescolares).
- La aerocámara aumenta el depósito pulmonar, reduce el depósito orofaríngeo y es tan eficaz como la nebulización en la crisis leve-moderada.
- Tras el corticoide inhalado, enjuagar la boca (previene candidiasis oral y disfonía).
- Revisar la técnica en cada control: la mala técnica es la causa más frecuente de mal control del asma antes de subir de escalón.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 6 años con asma usa salbutamol en inhalador presurizado de dosis medida. La madre refiere que no mejora durante las crisis. Al observar la técnica, el niño dispara el inhalador directamente en la boca y respira rápidamente. **¿Cuál es la indicación más adecuada para mejorar la técnica?**

A Cambiar a salbutamol en jarabe

B Indicar nebulizaciones diarias permanentes

C Aumentar el número de puffs sin cambiar la técnica

D Usar aerocámara (espaciador), con mascarilla o boquilla según la edad, y realizar varias respiraciones tras cada puff

E Disparar el inhalador hacia la nariz

Respuesta D. La mayoría de los pacientes, especialmente los niños, no coordina el disparo con la inspiración, y gran parte del fármaco queda en la orofaringe. La aerocámara mejora el depósito pulmonar y reduce efectos locales: se agita el inhalador, se dispara un puff en la aerocámara y se respira 5 a 6 veces por puff. Los jarabes no se recomiendan.

▶ VER CLASE 1.05.5.007 Intubación traqueal

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.1 · Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: Glasgow ≤8 o incapacidad de proteger la vía aérea, paro, insuficiencia respiratoria refractaria o fracaso de la VMNI, shock grave, obstrucción inminente de vía aérea.
- Secuencia rápida: preparar equipo y aspiración, preoxigenar con O2 100% 3-5 min, inductor (ketamina —también broncodilata en asma—, etomidato o propofol) y relajante (succinilcolina o rocuronio); en trauma, restricción cervical en línea.
- Tubo 7,0-7,5 en mujeres y 7,5-8,0 en hombres (≥8,0 si se requiere broncoscopía o hemoptisis masiva); laringoscopía directa o video.
- Confirmar posición con capnografía de onda continua (el método más confiable); luego auscultación y radiografía (punta 2-4 cm sobre la carina).
- Nunca intubar ni ventilar con presión positiva un neumotórax a tensión sin descomprimir. Si falla: dispositivo supraglótico y, si no se oxigena, cricotiroidotomía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Se intuba a un paciente de 60 años por insuficiencia respiratoria aguda. Tras pasar el tubo se ausculta murmullo pulmonar bilateral, pero se requiere confirmar en forma objetiva que el tubo está en la tráquea. **¿Cuál es el método más confiable para confirmar de inmediato la intubación traqueal?**

A Empañamiento del tubo

B Ausencia de ruidos en el epigastrio

C Expansión torácica

D Saturometría a los 5 minutos

E Capnografía con curva de CO2 espirado persistente

Respuesta E. La capnografía de onda continua, que muestra CO2 espirado en ciclos sucesivos, es el método más confiable para confirmar la posición traqueal del tubo y detectar desplazamientos. Los signos clínicos pueden engañar y la saturación cae tardíamente en una intubación esofágica. Luego se verifica la altura del tubo con radiografía de tórax.

▶ VER CLASE 1.05.5.008 Nebulizaciones

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 1.2 · Crisis Asmática en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: crisis asmática grave con hipoxemia o paciente que no coordina ni puede usar aerocámara; en la crisis leve-moderada la aerocámara es igual de eficaz.
- Dosis habituales adulto: salbutamol 2,5-5 mg + ipratropio 500 mcg diluidos en 3-4 mL de suero fisiológico, c/20 min en la primera hora.
- En asma grave hipoxémica nebulizar con oxígeno a 6-8 L/min (corrige la hipoxemia); con aire comprimido puede empeorar la desaturación.
- En EPOC retenedor de CO2 preferir nebulizar con aire comprimido y oxígeno por cánula, para no exceder la meta de 88-92%.
- Técnica: paciente sentado, mascarilla bien ajustada o boquilla, respiración a volumen corriente hasta terminar la solución (~10 min); vigilar taquicardia, temblor e hipokalemia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 32 años, asmática, consulta en urgencia por disnea progresiva de 6 horas. Habla en palabras sueltas, FR 32/min, FC 124/min, SatO2 87% con aire ambiental, uso de musculatura accesoria y sibilancias difusas. Está muy ansiosa y no logra coordinar la inhalación. **¿Cuál es la forma más adecuada de administrar el broncodilatador inicial?**

A Salbutamol más bromuro de ipratropio nebulizados con oxígeno a 6-8 L/min

B Salbutamol en polvo seco inhalado

C Salbutamol en inhalador de dosis medida sin aerocámara

D Salbutamol nebulizado con aire comprimido, agregando oxígeno solo si persiste la hipoxemia

E Salbutamol endovenoso como primera línea

Respuesta A. Crisis asmática grave con hipoxemia en una paciente que no coordina: la nebulización impulsada por oxígeno a 6-8 L/min entrega el broncodilatador y corrige la hipoxemia a la vez, y en crisis grave se asocia ipratropio. Nebulizar con aire comprimido en una paciente hipoxémica empeora la desaturación. La vía endovenosa no es primera línea.

▶ VER CLASE 1.05.5.009 Punción pleural

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 3.1 · Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: diagnóstica en derrame >10 mm de causa no clara o paraneumónico; evacuadora en derrame que causa disnea.
- Técnica: paciente sentado inclinado hacia adelante, línea axilar posterior o escapular, 1-2 espacios bajo el nivel del derrame, idealmente guiada por ecografía; aguja sobre el borde superior de la costilla inferior.
- Muestras: proteínas y LDH (con suero simultáneo), glucosa, pH en jeringa de gases, recuento celular, ADA, citología, Gram y cultivos.
- Evacuadora: no extraer más de 1-1,5 L por sesión (edema pulmonar de reexpansión); suspender si aparece tos intensa, dolor o disnea.
- Complicaciones: neumotórax (radiografía si hay síntomas), hemotórax, reacción vasovagal, punción de hígado o bazo si se punciona muy bajo. Precaución con coagulopatía o anticoagulación.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 124

Un paciente de 43 años, con antecedentes de tabaquismo y consumo excesivo de alcohol, consulta por un cuadro de 5 días de evolución caracterizado por sensación febril, tos con expectoración mucopurulenta y en ocasiones hemoptoica. Al examen físico, se observa delgado, con T°: 38,5°C, frecuencia cardíaca: 100x', PA: 118/76 mmHg, saturación arterial de 95% y frecuencia respiratoria: 17x'. Su examen pulmonar muestra crepitaciones y algunos estertores bilaterales y su examen cardíaco muestra ritmo regular en dos tiempos, sin soplos. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar una prueba de quantiferón para tuberculosis

B Realizar una broncoscopia

C Solicitar una prueba de elisa de cuarta generación para VIH

D Realizar una toracocentesis diagnóstica y evacuadora

E Solicitar una tomografía axial computarizada (TAC) de tórax

Respuesta D. La radiografía mostraba un derrame pleural izquierdo en un cuadro de neumonía o tuberculosis. Lo más importante es puncionar: toracocentesis diagnóstica y evacuadora. El quantiferón solo sirve para la tuberculosis latente.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 70 años con derrame pleural derecho de causa no aclarada que ocupa un tercio del hemitórax. Se planifica toracocentesis diagnóstica con la paciente sentada, guiada por ecografía. **¿Cuál es el sitio y la técnica correctos de punción?**

A Borde inferior de la costilla superior, en la línea medioclavicular

B Borde superior de la costilla inferior, en la línea axilar posterior o escapular, un espacio bajo el nivel del derrame

C 2.º espacio intercostal en la línea medioclavicular

D Bajo el 10.º espacio intercostal para asegurar el máximo de líquido

E Sitio indistinto si se usa aguja fina

Respuesta B. El paquete vasculonervioso intercostal corre por el borde inferior de cada costilla; por eso se punciona sobre el borde superior de la costilla inferior. Con la paciente sentada, en la línea axilar posterior o escapular, idealmente guiado por ecografía, y sin bajar demasiado para no puncionar hígado o bazo.

▶ VER CLASE 1.05.5.010 Resucitación cardiorespiratoria

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 1.2 · Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

QUÉ HAY QUE SABER

- Soporte vital básico: asegurar la escena, comprobar respuesta, pedir ayuda, llamar a emergencias y pedir DEA; verificar respiración y pulso en ≤10 s (jadeo = paro).
- Compresiones de alta calidad en el centro del tórax: 100-120/min, 5-6 cm en adultos, reexpansión completa, interrupciones <10 s y cambio de reanimador cada 2 min.
- Relación 30:2 en adultos (un reanimador en todas las edades); en niños y lactantes con 2 reanimadores, 15:2. Lactante: 2 dedos o dos pulgares, profundidad ~4 cm; niño ~5 cm.
- DEA lo antes posible: encender, seguir instrucciones, descarga si es ritmo desfibrilable y reanudar compresiones de inmediato.
- Con vía aérea avanzada: compresiones continuas y 1 ventilación c/6 s. Paro respiratorio con pulso: 1 ventilación c/6 s sin compresiones.
- Evitar hiperventilar (aumenta la presión intratorácica y la distensión gástrica); continuar hasta que llegue soporte avanzado o se recupere la circulación.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años colapsa en la sala de espera. No responde, no respira normalmente y no se palpa pulso carotídeo. Se activa el sistema de emergencia y se pide el desfibrilador. **Mientras llega el desfibrilador, ¿cuál es la técnica correcta de compresiones torácicas?**

A 60-80 compresiones por minuto, profundidad de 2-3 cm, relación 15:2

B Más de 140 compresiones por minuto, profundidad de 7 cm, relación 30:2

C 100-120 compresiones por minuto, profundidad de 3-4 cm, relación 15:1

D 100-120 compresiones por minuto, profundidad de 5-6 cm, relación 30:2

E Ventilar durante 2 minutos antes de iniciar compresiones

Respuesta D. La RCP de alta calidad en el adulto consiste en compresiones a 100-120 por minuto, con 5-6 cm de profundidad, reexpansión completa del tórax y mínimas interrupciones, con relación 30:2 sin vía aérea avanzada. Se prioriza iniciar compresiones antes que ventilar (secuencia C-A-B) y desfibrilar apenas se disponga del equipo.

▶ VER CLASE 1.05.5.011 Ventilación mecánica invasiva

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.1 · Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)
Respiratorio 5.2 · Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: Glasgow ≤8, paro o paro inminente, fracaso de la VMNI (empeoran pH y PaCO2 en 1-2 h, sopor, secreciones, vómitos), shock, hipoxemia refractaria (SDRA).
- SDRA: ventilación protectora con Vt 6 mL/kg de peso ideal, presión plateau ≤30 cmH2O, PEEP optimizada y prono ≥16 h/día si PaFi <150.

- Parámetro de seguridad: la presión plateau refleja la presión alveolar; la peak incluye la resistencia de la vía aérea.
- Ventilación prolongada (>10-14 días o destete fallido): traqueostomía electiva.
- Complicaciones: neumonía asociada al ventilador, barotrauma (neumotórax), volutrauma, inestabilidad hemodinámica. Nivel del médico general: indicar, intubar si es necesario y derivar a UCI.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 72 años con exacerbación de EPOC, en ventilación mecánica no invasiva desde hace 2 horas. Ahora está en sopor, Glasgow 8, con abundantes secreciones que no logra expectorar y vómitos. FR 36/min. Gases: pH 7,17, PaCO2 88 mmHg (al ingreso pH 7,28 y PaCO2 68 mmHg). **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener la ventilación no invasiva y aumentar la presión inspiratoria

B Intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva

C Bicarbonato de sodio endovenoso

D Cambiar a oxígeno con mascarilla de alto flujo al 100 %

E Naloxona endovenosa

Respuesta B. Fracaso de la ventilación no invasiva: empeoramiento del pH y la PaCO2 tras 1 a 2 horas, compromiso de conciencia, incapacidad de manejar secreciones y vómitos. Son contraindicaciones para continuarla y obligan a intubar y conectar a ventilación invasiva. Insistir con la máscara retrasa la intubación y aumenta la mortalidad.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

¿Cuál es el parámetro fisiológico de seguridad en el ventilador mecánico que debe monitorizarse y mantenerse rigurosamente por debajo de 30 cmH2O para prevenir el barotrauma alveolar en un paciente con SDRA? **¿Cuál es el parámetro?**

A Presión inspiratoria peak (Ppeak)

B Presión meseta o plateau (Pplateau)

C Nivel de presión positiva al final de la espiración (PEEP)

D Presión de oclusión de la arteria pulmonar (POAP)

E Presión venosa central (PVC)

Respuesta B. La presión plateau, medida con una pausa al final de la inspiración, refleja la presión estática sobre el alvéolo. Mantenerla ≤ 30 cmH2O previene la sobredistensión y el barotrauma. La presión peak incluye la resistencia de la vía aérea y puede subir sin sobredistender el alvéolo.

▶ VER CLASE 1.05.5.012 Ventilación mecánica no invasiva

NIVEL **DERIVAR A ESPECIALISTA**

DÓNDE SE ENSEÑA

Respiratorio 1.5 · Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)
Respiratorio 5.1 · Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones de primera línea: exacerbación de EPOC con acidosis hipercápnica (pH 7,25-7,35 y PaCO2 >45) en paciente vigil y cooperador, y edema pulmonar cardiogénico (CPAP o BiPAP).
- Beneficio: reduce la intubación en >50% y la mortalidad intrahospitalaria en EPOC exacerbado; descansa el músculo y lava el CO2.
- Parámetros iniciales BiPAP: IPAP 10-15 cmH2O, EPAP 4-6 cmH2O, con O2 titulado a SatO2 88-92%; reevaluar gases en 1-2 h.
- Contraindicaciones (intubar): paro o paro inminente, Glasgow <8 o no protege la vía aérea, shock con drogas vasoactivas, vómitos incoercibles, trauma facial grave, secreciones abundantes.
- Si fracasa (empeora pH/PaCO2, compromiso de conciencia): intubación sin demora. Nivel del médico general: reconocer la indicación y derivar a unidad de cuidados intermedios o intensivos.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 163

Un paciente de 72 años, con antecedente de tabaquismo de 50 paquetes/año, complicado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa en tratamiento con salmeterol y fluticasona inhalados, presenta aumento de su tos y disnea desde hace 3 días, agregándose expectoración mucopurulenta y fiebre hasta 38,4 °C. Luego evoluciona con marcado aumento de su disnea, la que se vuelve de reposo. Al examen físico se observa agitado, orientado en tiempo y espacio, disneico, con uso de musculatura accesoria, frecuencia respiratoria: 40 rpm, saturación de oxígeno: 84%, frecuencia cardíaca: 108 lpm y presión arterial: 146/92 mmHg. El examen pulmonar muestra aumento del diámetro torácico, hipersonoridad a la percusión, sibilancias y roncus bilaterales difusos, con algunos crépitos más intensos en el lado derecho. Los gases arteriales muestran: PaO_2: 65 mmHg, $PaCO_2$: 55 mmHg, HCO_3^-: 28 mEq/L, pH: 7,29. Su hemograma muestra hematocrito: 50%, hemoglobina: 17 g/dL, plaquetas: 380.000/mm³ y glóbulos blancos: 14.500/mm³. Se inicia nebulización con broncodilatadores y se administran antibióticos y corticoides por vía endovenosa. **¿Cuál es la conducta más adecuada para su manejo respiratorio?**

A Oxígeno por mascarilla Venturi al 50%

B Oxígeno por mascarilla de no recirculación

C Oxígeno por naricera al 24%

D Oxígeno por cánula nasal de alto flujo a 15 L/min

E Ventilación mecánica no invasiva

Respuesta E. Acidosis respiratoria hipercápnica (pH 7,29, PaCO2 55): el problema es ventilatorio, no de oxigenación. Subir el oxígeno no corrige el CO2 y puede empeorarlo. Paciente orientado, sin contraindicaciones: VMNI.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 145

Paciente con EPOC exacerbado con pH <7,30 y pCO2 >49 mmHg tras O2, broncodilatadores, antibióticos y corticoides. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Intubación orotraqueal e inicio de VMI

B Ventilación mecánica no invasiva (VNI/BIPAP)

C Aumentar FiO2 a 60%

D Heliox y magnesio endovenoso

E Traslado a UCI sin cambiar manejo

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Ventilación mecánica no invasiva (VNI/BIPAP) (opción B). Ventilación mecánica no invasiva (VNI/BIPAP).

06
GASTROENTEROLOGÍA

64 CÓDIGOS

196 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	30
Situaciones clínicas de urgencia	12
Conocimientos generales	6
Exámenes e imagenología	15
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	1

Situaciones clínicas

30 códigos

▶ VER CLASE 1.06.1.001 **Ascitis** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.3 · Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Causa más frecuente: cirrosis con hipertensión portal; otras: carcinomatosis peritoneal, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, TBC.
- Paracentesis diagnóstica a todo paciente con ascitis de reciente inicio o cirrótico con ascitis que se hospitaliza o descompensa: GASA ≥1,1 g/dL = hipertensión portal; albúmina en líquido <1,5 g/dL = alto riesgo de PBE; PMN ≥250/mm³ = PBE.
- Manejo inicial de la no complicada: restricción de sodio (no de agua) + espironolactona ± furosemida; controlar peso, función renal y electrolitos.
- Ascitis a tensión: paracentesis evacuadora con albúmina ~8 g por litro extraído (si >5 L), previa paracentesis diagnóstica para descartar PBE.
- Evitar AINE y aminoglucósidos. Refractaria: paracentesis seriadas con albúmina, TIPS o trasplante.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología/hepatología para estudio etiológico y evaluación de trasplante.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años con cirrosis por alcohol, en control ambulatorio, consulta por aumento del perímetro abdominal en la última semana y febrículas. Examen: ascitis moderada, sin dolor peritoneal, sin encefalopatía. Hemodinámicamente estable. **¿Cuál es la primera conducta?**

A Aumentar la dosis de espironolactona y furosemida

B Paracentesis diagnóstica

C Paracentesis evacuadora de gran volumen sin estudio del líquido

D Iniciar lactulosa

E Derivar para instalación de TIPS

Respuesta B. Cirrótico con ascitis y fiebre: la primera conducta es la paracentesis diagnóstica para descartar PBE, antes de ajustar diuréticos o evacuar. Si hay ≥ 250 PMN/mm³, cefotaxima endovenosa + albúmina. Aunque la fiebre sea baja y no haya dolor, obliga a puncionar.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Cirrótico con ascitis refractaria a diuréticos que además ha tenido dos episodios de encefalopatía hepática en el último mes. El equipo tratante propone instalar un TIPS para controlar la ascitis. **¿Cuál es la conducta correcta?**

A Instalar el TIPS: resuelve simultáneamente la ascitis y reduce el riesgo de várices

B No instalar el TIPS: la encefalopatía es una contraindicación

C Instalar el TIPS solo si se agrega lactulosa profiláctica

D Instalar el TIPS y suspender los betabloqueadores

E Instalar el TIPS con anestesia general para evitar la descompensación

Respuesta B. El TIPS hace que la sangre intestinal "salte" el hígado: alivia la hipertensión portal, pero aumenta el amonio y las toxinas que llegan al cerebro. La encefalopatía, aun leve o recurrente, lo contraindica. Se mantienen paracentesis seriadas con albúmina y se prioriza la evaluación para trasplante.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 125

Un paciente fumador de 20 paquetes-año, que consume cerca de 5 g de alcohol al día los fines de semana, presenta molestias abdominales inespecíficas y distensión abdominal progresiva desde hace 3 meses, a lo que en el último tiempo se agregó dolor abdominal. Se observa el paciente enflaquecido, con FC: 70x', PA: 130/80 mmHg y, en el examen abdominal, se constata ascitis a tensión, sin circulación colateral. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran GOT: 48 U/L, GPT: 37 U/L, GGT: 59 U/L, bilirrubina total: 1,3 mg/dL, bilirrubina directa: 0,3 mg/dL, protrombinemia: 80% y albuminemia: 2,9 g/dL. Además, se realiza paracentesis diagnóstica que muestra líquido ascítico con 680 células/mm³, 80% mononucleares y 20% polimorfonucleares, glucosa: 116 mg/dL, proteínas: 1,36 g/dL y ADA: 3,4 U/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Peritoni2s bacteriana espontánea

B Asci2s por hipertensión portal

C Síndrome nefró2co

D Tuberculosis peritoneal

E Carcinomatosis peritoneal

Respuesta E. Parece una carcinomatosis tanto por la clínica de cáncer (fumador, baja de peso, cuadro progresivo) como por el análisis con un exudado mononuclear y ADA baja (se interpreta similar al estudio de líquido pleural). No es una PBE (peritonitis bacteriana espontánea), ya que requiere más de 250 PMN y predominio PMN.

▶ VER CLASE 1.06.1.002 **Cáncer de páncreas** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.1 · Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en adulto mayor con ictericia progresiva e indolora, baja de peso, dolor epigástrico sordo irradiado al dorso; tumor de cabeza de páncreas es el más frecuente.

- Las '3 D': diabetes de reciente inicio en adulto mayor, depresión inexplicada y dolor sordo; signo de Courvoisier-Terrier (vesícula palpable e indolora con ictericia).
- Laboratorio: patrón colestásico (bilirrubina directa, FA y GGT altas); CA 19-9 sirve para seguimiento, no para diagnóstico.
- Estudio: ecografía primero (vía biliar dilatada, masa) y luego TAC de abdomen con contraste (examen de elección para el páncreas y etapificación).
- Mal pronóstico; solo la resección (Whipple) es potencialmente curativa en tumores resecables; en irresecables, paliación de la ictericia con prótesis por CPRE.
- Seguimiento: derivar a cirugía/oncología.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 70 años con ictericia progresiva de 6 semanas, prurito, coluria y baja de 8 kg. Sin dolor abdominal ni fiebre. Diabetes diagnosticada hace 2 meses. Al examen: ictericia marcada y vesícula palpable, no dolorosa. Laboratorio con patrón colestásico. **Tras la ecografía, que sugiere una masa pancreática, ¿cuál es el examen de elección?**

A CPRE diagnóstica

B TAC de abdomen con contraste

C Colangiorresonancia

D Biopsia hepática percutánea

E Anticuerpos antimitocondriales

Respuesta B. Ictericia indolora, baja de peso, diabetes reciente y signo de Courvoisier-Terrier: cáncer de cabeza de páncreas. La ecografía va primero; si sugiere masa pancreática, el examen de elección es el TAC con contraste. La colangiorresonancia es de elección para la vía biliar, no para el páncreas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 85

Un paciente de 60 años consulta por ictericia de dos semanas de evolución, que ha ido en aumento y se ha asociado a orinas oscuras. Como antecedente, es hipertenso y fumador de 5 paquetes-año. Su examen físico muestra ictericia de escleras y piel, sin alteraciones en el examen abdominal. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran SGOT: 72 U/L, SGPT: 48 U/L, GGT: 115 U/L, fosfatasa alcalina 200: U/L y bilirrubina: 4,9 mg/dL, de predominio directo. Se realiza ecografía abdominal que muestra vesícula biliar dilatada de 16 × 8 cm y dilatación de la vía biliar intrahepática y extrahepática. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Tumor de páncreas

B Colangiocarcinoma

C Colangi2s esclerosante primaria

D Diveraculo duodenal

E Colangi2s infecciosa

Respuesta A. Es una pregunta algo difícil. Tiene una ictericia obstructiva, con un patrón colestásico, lo que hace sospechar un cáncer que obstruye la vía biliar. La dilatación de la vesícula (signo de Courvoisier-Terrier) y la dilatación de la vía biliar extrahepática es característica de la obstrucción distal del colédoco, por lo que lo más probable es que sea un cáncer de cabeza de páncreas. El antecedente de fumar también orienta a esa causa. El divertículo duodenal es mucho más infrecuente. El...

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 66

Adulto fumador con ictericia, coluria, prurito y acolia, con patrón colestásico. ¿Diagnóstico más probable?

A Coledocolitiasis

B Colangitis esclerosante primaria

C Hepatitis viral colestásica

D Colangiocarcinoma

E Cáncer de páncreas

Respuesta E. Diagnóstico: Cáncer de páncreas (opción E). Cáncer de páncreas. Esta clase aborda cómo diferenciar la insuficiencia renal aguda de la crónica en la práctica clínica, dado que el paciente habitualmente no sabe cuánto tiempo lleva con la creatinina elevada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 147

Un paciente de 80 años presenta una clínica de 3 semanas de evolución de astenia, prurito e ictericia, asociada a malestar epigástrico. Además, refiere que ha bajado de peso en los últimos meses. Su examen físico muestra ictericia de piel y escleras, IMC: 19, signos vitales dentro de límites normales y examen abdominal que no aporta mayor información. Se solicitan exámenes que muestran bilirrubina plasmática: 12,4 mg/dl, con bilirrubina directa: 7,7 mg/dl, GOT: 120 UI/L, GPT: 89 UI/L, fosfatasas alcalinas: 870 UI/L y GGT: 688 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Coledocolitiasis

B Cáncer ampular

C Cáncer de páncreas

D Colangiocarcinoma

E Colangitis aguda

Respuesta C. Diagnóstico: Cáncer de páncreas (opción C). Esta clase aborda cómo diferenciar la insuficiencia renal aguda de la crónica en la práctica clínica, dado que el paciente habitualmente no sabe cuánto tiempo lleva con la creatinina elevada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 52

Un paciente de 49 años, fumador, presenta un cuadro de dispepsia postprandial de 4 meses de evolución, asociado a astenia, palidez, ictericia y prurito, que aumenta en las noches. Se solicitan exámenes que muestran hemograma normal y pruebas hepáticas que resultan GOT: 23 UI/L, GPT: 28 UI/L, bilirrubina total: 9,7 mg/dl, bilirrubina directa: 8,5 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 322 UI/L y GGT: 131 UI/L, con protrombinemia 80% y albúmina: 3,2 g/dl. El examen de elección para el estudio de este paciente es:

A Endoscopía digestiva alta
B Ecotomografía abdominal
C TAC abdominal
D Colangiografía por RMN
E Colangiografía endoscópica retrógrada

Respuesta C. Es un probable cáncer con obstrucción de la vía biliar (colestasia silente), probable cáncer de páncreas, por ser fumador. Es una pregunta muy difícil, porque el examen de primera línea de la colestasia silente es la Ecografía abdominal, mientras que el examen de elección, para el cáncer de páncreas en específico, es el TAC abdominal con contraste. Finalmente, el mejor examen para ver las ictericias malignas en general es la colangioRMN y se suele pedir después de la Ecografía. Por la clínica...

▶ VER CLASE 1.06.1.003 Cáncer de vesícula y vías biliares

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.4 · Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares

QUÉ HAY QUE SABER

- Chile tiene una de las tasas más altas del mundo de cáncer de vesícula; factor principal: colelitiasis de larga data (más en mujeres, mapuches, obesas).
- Prevención GES: colecistectomía preventiva en personas de 35 a 49 años con colelitiasis; en Chile toda colelitiasis se opera, incluso asintomática.
- Otros factores: vesícula en porcelana o escleroatrófica, pólipos ≥10 mm, colangitis esclerosante primaria.
- Clínica tardía e inespecífica: dolor en hipocondrio derecho, baja de peso, ictericia (por invasión de la vía biliar), masa palpable. Colangiocarcinoma: ictericia indolora progresiva.
- Estudio: ecografía, luego TAC o RM; muchos se descubren en la biopsia de una colecistectomía (si es invasor, reoperación con colecistectomía radical).
- Seguimiento: derivar a cirugía digestiva/oncología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 180

Mujer de 91 años, diabética, con antecedente de cólicos biliares a repetición, consulta por astenia, decaimiento, ictericia marcada y orinas oscuras de 3 semanas de evolución, asociadas a dolor epigástrico moderado. Al examen físico se aprecia ictericia de piel y mucosas y se palpa una masa en el hipocondrio derecho. Las pruebas hepáticas muestran SGOT 60 UI/L, SGPT 56 UI/L, GGT 570 UI/L, FA 755 UI/L, bilirrubina total 21 mg/dL y bilirrubina directa 19 mg/dL. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Cáncer de la cabeza de páncreas
B Cáncer de vesícula
C Colangiocarcinoma
D Hepatocarcinoma
E Cáncer de la ampolla de Vater

Respuesta B. Colestasia marcada con masa en hipocondrio derecho en una mujer mayor con cólicos biliares de larga data orienta a cáncer de vesícula, muy frecuente en Chile. La colelitiasis es su principal factor de riesgo, y por eso existe la colecistectomía preventiva GES entre los 35 y 49 años.

▶ VER CLASE 1.06.1.004 Cáncer gástrico

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.5 · Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Chile: 1.ª causa de muerte por cáncer en hombres y 2.ª en mujeres. Causa principal H. pylori; también atrofia y metaplasia intestinal, familiar con cáncer gástrico, sal y ahumados.
- Sospechar: epigastralgia idéntica a la úlcera en ≥40 años, baja de peso, anemia ferropénica, síndrome pilórico (vómitos de retención), masa o ganglio de Virchow.
- Endoscopía digestiva alta con biopsias (GES) a todo paciente ≥40 años con epigastralgia o con signos de alarma; toda úlcera gástrica se biopsia.
- Etapificación con TAC de tórax, abdomen y pelvis; incipiente si no pasa la submucosa (independiente de las adenopatías), avanzado si compromete la muscular propia.
- Tratamiento: incipiente resección endoscópica o gastrectomía; avanzado gastrectomía con linfadenectomía D2 + quimioterapia perioperatoria.
- Seguimiento: derivar a cirugía digestiva/oncología (GES).

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 121

Un paciente de 55 años presenta pirosis, mayor postprandial, que inició hace 2 meses y ha ido en aumento. Además tiene baja de 4 kg de peso en ese periodo, dolor abdominal que aumenta al palpar el epigastrio, y en el último tiempo se han agregado vómitos postprandiales. **¿Cuál es el examen que debe solicitarse para estudiar a este paciente?**

A Endoscopía digestiva alta
B pH-metría de 24 horas
C TAC de abdomen
D Ecografía abdominal
E Marcadores tumorales

Respuesta A. Baja de peso, dolor epigástrico y vómitos postprandiales en dos meses es un cuadro sospechoso de cáncer gástrico. Lo primero, siempre, es confirmarlo con endoscopía digestiva alta y biopsia; el TAC y los marcadores vienen después, si el diagnóstico se confirma.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 91

Un hombre de 57 años presenta epigastralgia, inapetencia y baja de peso, de 2 meses de evolución, a lo cual se agrega un episodio de melena, por el que consulta. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Cáncer gástrico
B Úlcera gastroduodenal
C Cáncer de esófago
D Linfoma gástrico asociado a mucosa
E Gastritis erosiva

Respuesta A. Epigastralgia, inapetencia y baja de peso, con melena que confirma una hemorragia digestiva alta, es el cuadro clásico del cáncer gástrico. La úlcera daría dolor urente pero sin baja de peso marcada, y el cáncer de esófago daría disfagia, más que inapetencia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 133

Paciente de 65 años, con antecedente de tabaquismo crónico de 30 paquetes-año, consulta por 3 meses de compromiso del estado general, pirosis y baja de 10 kg de peso. Al examen físico se aprecia decaído, deshidratado y muy enflaquecido, con leve edema simétrico en las extremidades inferiores. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Cáncer pulmonar
B Cáncer gástrico
C Cáncer de esófago
D Cáncer de páncreas
E Cáncer de duodeno

Respuesta B. La pirosis y la gran baja de peso orientan a estómago; no hay disfagia, que es lo clásico del cáncer de esófago. El edema de extremidades inferiores se explica por la desnutrición proteica de un cáncer avanzado, no por el tabaquismo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años con 3 meses de plenitud posprandial y vómitos de alimentos ingeridos horas antes, cada vez más frecuentes, y baja de 9 kg. Al examen: chapoteo gástrico de ayuno y una pequeña adenopatía supraclavicular izquierda. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Úlcera duodenal no complicada
B Cáncer gástrico avanzado con obstrucción de la salida gástrica
C Acalasia
D Dispepsia funcional
E Cáncer de páncreas

Respuesta B. Síndrome pilórico (vómitos de retención en aumento) con baja de peso y ganglio de Virchow: cáncer gástrico avanzado hasta demostrar lo contrario. Se confirma con endoscopía y biopsias y se etapifica con TAC. La adenopatía supraclavicular indica enfermedad metastásica y contraindica la cirugía curativa.

▶ VER CLASE 1.06.1.005 Cirrosis hepática

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.3 · Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Causas: alcohol, hígado graso metabólico (NASH), virus B y C, autoinmunes. Estigmas: arañas vasculares, eritema palmar, ginecomastia, circulación colateral, esplenomegalia.
- Diagnóstico: clínica + laboratorio (plaquetas bajas, albúmina baja, INR alto, bilirrubina) + ecografía (hígado nodular, esplenomegalia, ascitis); fibrosis por elastografía o biopsia.
- Gravedad con Child-Pugh (bilirrubina, albúmina, INR, ascitis, encefalopatía) y MELD.
- Manejo inicial: tratar la causa (abstinencia de alcohol, antivirales), vacunar contra hepatitis A y B, neumococo e influenza; evitar AINE y sedantes; no restringir proteínas.
- Endoscopía a todo cirrótico para buscar várices (propranolol o carvedilol si nunca sangraron); ecografía ± AFP cada 6 meses para tamizaje de hepatocarcinoma.

- Seguimiento: derivar a gastroenterología; descompensación (ascitis, HDA, encefalopatía, PBE) obliga a hospitalizar y evaluar trasplante.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Paciente con cirrosis y várices esofágicas medianas encontradas en una endoscopía de tamizaje. Nunca ha presentado hemorragia digestiva. **¿Cuál es la profilaxis indicada?**

A Ligadura endoscópica de várices + propranolol
B Propranolol (o carvedilol) por vía oral, titulado por frecuencia cardíaca
C Instalación electiva de TIPS
D Terlipresina endovenosa mensual
E Ácido tranexámico oral permanente

Respuesta B. Profilaxis primaria (nunca sangró): betabloqueo no selectivo, titulado para reducir la frecuencia cardíaca. La ligadura se añade en la profilaxis secundaria o se usa sola si el betabloqueo está contraindicado (asma, EPOC grave, intolerancia).

▶ VER CLASE 1.06.1.006 Colelitiasis

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 4.1 · Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Cólico biliar: dolor sordo en epigastrio o hipocondrio derecho de 30–60 min, tras comidas grasas, con náuseas, que cede solo.
- Diagnóstico con ecografía abdominal: imagen hiperecogénica con sombra acústica en la vesícula.
- Manejo agudo: analgesia con dipirona + antiespasmódico (o AINE); régimen hipograso.
- En Chile toda colelitiasis se opera (incluso asintomática) por riesgo de complicaciones y de cáncer de vesícula; GES de colecistectomía preventiva entre 35 y 49 años.
- Sumar síntomas: + fiebre/Murphy = colecistitis; + ictericia = coledocolitiasis; + ictericia + fiebre = colangitis; dolor al dorso con lipasa alta = pancreatitis.
- Seguimiento: derivar a cirugía para colecistectomía laparoscópica electiva.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 146

Paciente de 55 años con 3 días de dolor abdominal, mayor en epigastrio, con vómitos alimentarios. Ecografía: vía biliar de 8 mm, con múltiples cálculos pequeños en la vesícula. Fosfatasas alcalinas 520 U/L, GGT 612 U/L, GOT 102 U/L, GPT 87 U/L, bilirrubina total 6,0 mg/dL (directa 4,6). **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
B Indicar colangiorresonancia
C Solicitar TAC de abdomen y pelvis
D Resolver quirúrgicamente
E Indicar tratamiento analgésico y antibiótico endovenoso

Respuesta B. Dolor con patrón colestásico y colédoco dilatado, sin fiebre ni compromiso hemodinámico: coledocolitiasis, sin criterios de colangitis. Como la ecografía no vio el cálculo directamente, el paso siguiente es confirmar con colangiorresonancia, y recién si esta lo ve, se hace la CPRE.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 66

Un paciente de 55 años, sin antecedentes, consulta por dolor epigástrico intenso asociado a vómitos biliosos. Al examen físico destacan escleras ictéricas, sensibilidad a la palpación epigástrica. Se realizan exámenes donde destaca leucocitos 13.000/mm³, PCR 50 mg/dL, GOT 120 U/L, GPT 140 U/L, bilirrubina 3 mg/dL, fosfatasas alcalinas 400 U/L, lipasa 100 U/L. Ecografía abdominal con vía biliar extrahepática dilatada. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Colangitis aguda
B Pancreatitis aguda
C Colecistitis aguda
D Coledocolitiasis
E Hepatitis aguda

Respuesta D. Tiene una coledocolitiasis: patrón colestásico con vía biliar dilatada. La lipasa está elevada pero no llega a tres veces el límite superior normal, así que no cumple criterio de pancreatitis. Los leucocitos y la PCR llaman la atención, pero la clínica no alcanza para colangitis, que exige la tríada de Charcot completa.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 40 años, sin síntomas, a quien en una ecografía de rutina se le detecta colelitiasis (múltiples cálculos, vesícula de pared normal). **¿Cuál es la conducta?**

A Observación; operar solo si aparecen síntomas

B Ácido ursodesoxicólico para disolver los cálculos

C Colecistectomía laparoscópica electiva

D Dieta baja en grasas y control ecográfico anual

E Colecistectomía solo si los cálculos superan los 2 cm

Respuesta C. En Chile, con la incidencia de cáncer de vesícula más alta del mundo, toda colelitiasis, aun asintomática, se trata con colecistectomía laparoscópica electiva. El GES la garantiza entre los 35 y 49 años. La disolución y la observación no protegen del cáncer.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 174

Una paciente de 40 años, IMC: 30, presenta dolor intermitente en el hipocondrio derecho, desde hace 3 meses, que cede espontáneamente. Se realiza una ecografía, que se muestra a continuación: Fuente: www.radiopaedia.org El diagnóstico más probable es:

A Colelitiasis

B Coledocolitiasis

C Colangiocarcinoma

D Cáncer de vesícula

E Colecistitis

Respuesta A. Es una imagen clásica de cálculos biliares, con la sombra acústica característica de los cálculos. La clínica son cólicos biliares.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 36

Un paciente presenta hace una semana dolor en el hipocondrio derecho, intenso, asociado a vómitos, que cede espontáneamente. Actualmente está en buenas condiciones, asintomático, sin alteraciones en el examen físico. ¿Qué examen es el más adecuado para estudiar a este paciente?

A Ecografía abdominal

B Radiografía de abdomen

C Amilasa / Lipasa

D Colangioresonancia

E TAC de abdomen

Respuesta A. Probablemente tiene una colelitiasis (clínica de cólico biliar). Se estudia con Eco. En agudo sí debió haberse pedido la amilasa/lipasa para descartar pancreatitis, pero ahora solo hay que descartar la colelitiasis.

▶ VER CLASE 1.06.1.007 Colestasia

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.1 · Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Ictericia con bilirrubina directa >30 % del total y FA + GGT elevadas (la GGT confirma el origen hepatobiliar; FA alta con GGT normal: hueso).
- Con dolor: coledocolitiasis; con dolor + fiebre + ictericia (Charcot): colangitis, urgencia. Sin dolor en adulto mayor con baja de peso: cáncer (páncreas primero).
- Crónicas autoinmunes: colangitis biliar primaria (mujer 40–60, prurito, AMA +, ácido ursodesoxicólico) y colangitis esclerosante primaria (hombre joven con colitis ulcerosa, p-ANCA).
- Estudio siempre primero con ecografía (vía biliar dilatada, colédoco >6–7 mm, masa); luego colangiorresonancia para la vía biliar o TAC si se sospecha masa pancreática.
- Manejo inicial: analgesia, suspender fármacos colestásicos; colangitis: volumen + antibióticos + CPRE urgente.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología o cirugía según la causa.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 174

Mujer de 54 años se realiza exámenes como parte de un chequeo médico, que muestran GOT 43 UI/L, GPT 70 UI/L, GGT 433 UI/L, FA 531 UI/L, bilirrubina total 3,0 mg/dL, albúmina 3,7 g/dL y protrombinemia 88 %. **¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?**

A Colestasia por esteatosis hepática

B Cirrosis biliar primaria

C Colestasia por compresión externa

D Colangitis esclerosante primaria

E Colangitis esclerosante secundaria

Respuesta B. Mujer de edad media con colestasia de laboratorio (FA y GGT muy elevadas, transaminasas casi normales) y función hepática conservada: lo más probable es la cirrosis biliar primaria, hoy llamada colangitis biliar primaria. Se confirma con anticuerpos antimitocondriales. La colangitis esclerosante primaria es más propia de hombres con colitis ulcerosa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 136

Una mujer de 49 años consulta prurito generalizado, que es mayor en las palmas y plantas y que aumenta en la noche. Se realiza pruebas hepáticas que muestran GOT: 48 UI/L, GPT: 50 UI/L, GGT: 710 UI/L, FA: 689 UI/L, bilirrubina total: 2,0 mg/dl y bilirrubina directa: 0,6 mg/dl, albúmina: 4,0 g/dl y protrombinemia 100%. El examen de elección para proseguir el diagnóstico es:

A Cuantificación de inmunoglobulina E sérica
B Colangioresonancia
C Ácidos biliares
D Anticuerpos antinucleares
E Anticuerpos antimitocondriales

Respuesta E. Tiene una colestasia clínica (prurito palmoplantar mayor en la noche) y de laboratorio (elevación de la GGT, FA y bilirrubina). Por la edad y por ser mujer, lo más probable es que sea una cirrosis biliar primaria (CBP), por lo que se estudia con los AMA (anticuerpos antimitocondriales) y luego se confirma con la biopsia hepática (se trata con ácido ursodeoxicólico, que ayuda a disminuir los síntomas). La clínica más frecuente de la CBP es con marcada astenia y eventualmente prurito e ictericia....

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 49

Una paciente de 55 años, se realiza exámenes como parte de chequeo médico, que muestran GOT: 54 UI/L, GPT: 70 UI/L, GGT: 654 UI/L, FA: 455 UI/L, bilirrubina total: 1,0 mg/dl, albúmina: 3,7 g/dl y protrombinemia: 90%. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

A Coledocolitiasis
B Cirrosis biliar primaria
C Colestasia por obstrucción neoplásica
D Colangitis esclerosante primaria
E Colangitis esclerosante secundaria

Respuesta B. Tiene colestasia en las pruebas hepáticas, sin hepatitis (por las GOT y GPT mínimamente elevadas) ni falla hepática (protrombinemia y albúmina normales). Por ser mujer y de esa edad lo más probable es una CBP, la que, además, se demora en elevar la bilirrubinemia, afectando mucho más las FA y luego la GGT. La coledocolitiasis tendría dolor y mucha más ictericia. El cáncer produce bastante ictericia también. La CEP (opción D) suele asociarse a colitis ulcerosa o enfermedad de Cröhn y afectar más a hombres.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 118

Una paciente de 40 años presenta marcada astenia y prurito intenso, en particular en las manos, que no ha respondido al tratamiento antihistamínico, indicado por el dermatólogo. En sus exámenes tiene hematocrito: 42%, blancos: 5.000, con 9% de eosinófilos, GOT: 58 UI/L, GPT: 39 UI/L, GGT: 300 UI/L, bilirrubina 2,0 UI/l, FA: 700 UI/L. ¿CUál es el examen para continuar el estudio?

A Serología de virus hepatitis
B Anticuerpos antinucleares
C Ecografía hepática
D Parasitológico de deposiciones
E Anticuerpos antimitocondriales

Respuesta E. Cuadro de cirrosis biliar primaria. Se estudia con anticuerpos antimitocondriales (AMA). Luego la Biopsia hepática).

▶ VER CLASE 1.06.1.008 **Trastornos digestivos funcionales** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.1 · Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable

QUÉ HAY QUE SABER

- Síntomas digestivos crónicos sin lesión estructural (eje cerebro-intestino, hipersensibilidad visceral); diagnóstico positivo, no de descarte.
- Intestino irritable (Roma IV): dolor abdominal ≥1 día/semana en los últimos 3 meses + ≥2 de: relación con la defecación, cambio de frecuencia o de consistencia. Dispepsia funcional: requiere endoscopía normal.
- Descartar alarma (ABCDEFH): anemia, baja de peso, cambio reciente del hábito, disfagia, inicio >50 años, familiar con cáncer, hemorragia o síntomas nocturnos; ante alarma, EDA o colonoscopía.
- Exámenes básicos: hemograma, PCR, TSH, serología celíaca; calprotectina si hay diarrea.
- Tratamiento: educación y explicar benignidad, manejo del estrés, dieta baja en FODMAP y fibra soluble; dolor: antiespasmódicos (trimebutino, pinaverio); diarrea: amitriptilina en dosis baja; constipación: polietilenglicol.
- Seguimiento completo en APS; reevaluar si aparecen signos de alarma.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 32 años con 8 meses de dolor en hipogastrio que alivia tras defecar, con períodos alternados de diarrea y constipación. Sin baja de peso, rectorragia ni anemia. Examen físico y hemograma normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Colonoscopía para descartar cáncer de colon

B TAC de abdomen y pelvis con contraste

C Diagnosticar SII e iniciar educación y dieta baja en FODMAP

D Endoscopía digestiva alta con biopsias

E Test de sangre oculta en deposiciones

Respuesta C. Cumple Roma IV (dolor recurrente relacionado con la defecación, con cambio en la frecuencia y forma de las deposiciones) y no tiene signos de alarma. El diagnóstico de SII es clínico y positivo: no requiere colonoscopía ni imágenes. Manejo: educación, dieta baja en FODMAP y fármacos según el síntoma.

▶ VER CLASE 1.06.1.009 Constipación

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.2 · Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

QUÉ HAY QUE SABER

- Menos de 3 deposiciones a la semana, duras o con esfuerzo; casi siempre funcional (Roma IV) o asociada a fármacos (opioides, anticolinérgicos, calcio, hierro).
- Descartar causas secundarias: hipotiroidismo, hipercalcemia, diabetes, Parkinson, depresión.
- Signos de alarma (inicio >50 años, cambio reciente del hábito, anemia, rectorragia, baja de peso, familiar con cáncer de colon): colonoscopía.
- Tratamiento escalonado: fibra (20–30 g/día) y agua, actividad física, educación del hábito defecatorio; luego laxantes osmóticos (polietilenglicol, lactulosa); estimulantes (bisacodilo, sen) de rescate.
- Impactación fecal: enemas o desimpactación manual, sobre todo en adulto mayor.
- Seguimiento completo en APS; derivar si es refractaria o hay alarma.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 119

Mujer de 27 años con constipación de 3 años de evolución, con deposiciones caprinas y duras, que evacua una vez a la semana. Se realiza una radiografía de abdomen que muestra dolicocolon, con contenido fecal en toda su extensión. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Laxantes osmóticos

B Laxantes de contacto

C Cambios de hábitos

D Proquinéticos

E Cirugía

Respuesta C. En una paciente joven sin signos de alarma, la constipación funcional se trata primero con cambios de hábitos: fibra, líquidos, actividad física y horario defecatorio. El dolicocolon es un hallazgo sin relevancia terapéutica y no justifica cirugía. Los laxantes quedan como segunda línea si las medidas fallan.

▶ VER CLASE 1.06.1.010 Diarrea asociada a antibióticos

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.2 · Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

QUÉ HAY QUE SABER

- Diarrea que aparece durante o hasta 8 semanas después de un antibiótico (clindamicina, cefalosporinas, quinolonas); la mayoría es leve y osmótica.
- Clostridioides difficile: diarrea acuosa con fiebre, dolor y leucocitosis; forma grave con colitis pseudomembranosa o megacolon tóxico.
- Diagnóstico: PCR o toxina de C. difficile en deposiciones diarreicas; no se pide PCR de control tras el tratamiento.
- Manejo: suspender el antibiótico gatillante si es posible, hidratar, evitar antidiarreicos (loperamida).
- C. difficile: metronidazol en casos leves (según la clase) o vancomicina oral 125 mg c/6 h por 10 días (de elección en guías actuales); fidaxomicina alternativa; recurrencias: vancomicina en esquema prolongado o trasplante fecal.
- Seguimiento: control clínico; prevención con uso racional de antibióticos e higiene de manos con agua y jabón.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 110

Puérpera de 5 días, hospitalizada durante el parto, presenta deposiciones líquidas múltiples con moco y sangre, calambres abdominales y fiebre de 38,5 °C. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Infección por Clostridioides difficile
B Gastroenteritis viral
C Colitis ulcerosa de novo
D Salmonelosis
E Síndrome de intestino irritable postinfeccioso

Respuesta A. La hospitalización y los antibióticos del periparto (profilaxis o cesárea) son el principal factor de riesgo de Clostridioides difficile, que causa diarrea con fiebre, dolor cólico y a veces sangre. Se confirma con toxinas o PCR en deposiciones y se trata con vancomicina o fidaxomicina oral. Una gastroenteritis viral rara vez es disentérica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 107

Una paciente de 31 años, con antecedente de parto hace 3 meses, consulta por un cuadro de diarrea de dos meses de evolución de tipo acuoso que ha empeorado en los últimos días, no ha presentado fiebre ni sangre en sus deposiciones. En su examen físi- co presenta dolor difuso a la palpación abdominal y meteorismo. El diagnóstico más probable es:

A Enfermedad celiaca
B Colitis ulcerosa
C Diarrea nosocomial
D Enteroparasitosis
E Diarrea crónica funcional

Respuesta C. En el parto recibió antibióticos y la diarrea por clostridium puede aparecer hasta 2 meses después de haber terminado el uso de antibióticos. Eso sí, se debe ser cuidado- so, porque hay quienes definen a la diarrea nosocomial en términos más estrictos, que no calzan con el del caso clínico.

▶ VER CLASE 1.06.1.011 Diarrea crónica

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.2 · Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

QUÉ HAY QUE SABER

- Diarrea de 4 semanas o más; prolongada si dura 2–4 semanas.
- Orientar por la clínica: funcional (SII, sin alarma), malabsorción (esteatorrea, baja de peso con ingesta conservada, carencias), inflamatoria (sangre, fiebre, calprotectina alta) o secretora.
- Estudio inicial: hemograma, PCR, TSH, anti-transglutaminasa IgA con IgA total, coprocultivo y parasitológico seriado (Giardia), Sudán; D-xilosa localiza (pared vs enzimas).
- Signos de alarma (sangre, baja de peso, anemia, edad >50, síntomas nocturnos): colonoscopía con biopsias.
- Manejo inicial: hidratación, tratar causas evidentes (suspender fármacos, lactosa, parásitos).
- Seguimiento: derivar a gastroenterología si no se aclara la causa o hay alarma.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años con 4 meses de diarrea acuosa, 4 a 5 veces al día, que la despierta en la noche, con baja de 6 kg. No ha viajado. Al examen hay palidez leve. Hemoglobina 10,5 g/dL y VCM 76 fL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Diagnosticar síndrome de intestino irritable e indicar dieta baja en FODMAP
B Loperamida y control en 3 meses
C Coprocultivo como único examen
D Estudio de diarrea crónica orgánica, con exámenes de laboratorio y colonoscopía con biopsias
E Metronidazol empírico por 7 días

Respuesta D. Diarrea de más de 4 semanas con signos de alarma —nocturna, baja de peso y anemia— es orgánica hasta demostrar lo contrario. Se estudia con laboratorio (hemograma, PCR, serología celíaca, parasitológico) y colonoscopía con biopsias. El intestino irritable no despierta en la noche ni produce anemia.

▶ VER CLASE 1.06.1.012 Diarrea en inmunosuprimidos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.2 · Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

QUÉ HAY QUE SABER

- En VIH con CD4 bajos, trasplantados o quimioterapia: diarrea crónica, profusa, con baja de peso; el agente depende del grado de inmunosupresión.
- Agentes oportunistas: Cryptosporidium, Cystoisospora, microsporidios, Giardia; CMV (colitis con CD4 <50, úlceras en colonoscopía) y complejo Mycobacterium avium; también C. difficile y bacterias habituales.
- Estudio: coprocultivo, parasitológico con tinción de Ziehl-Neelsen modificada (Cryptosporidium, Cystoisospora), toxina C. difficile; colonoscopía con biopsias si es persistente.
- Manejo inicial: hidratación, corrección de electrolitos y soporte nutricional; tratamiento dirigido (cotrimoxazol para Cystoisospora, ganciclovir para CMV).

- La terapia antirretroviral con recuperación de CD4 es clave en la criptosporidiosis.
- Seguimiento: derivar a infectología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 34 años con infección por VIH sin tratamiento, con CD4 de 45 células/mm3, consulta por diarrea acuosa abundante de 6 semanas, sin sangre, y baja de peso de 7 kg. El coprocultivo y el examen parasitológico seriado habitual de deposiciones son negativos. **¿Cuál es el examen más útil para continuar el estudio?**

A Elastasa fecal

B Test de hidrógeno espirado

C Anticuerpos antitransglutaminasa

D Sangre oculta en deposiciones

E Tinción de Ziehl-Neelsen modificada en deposiciones

Respuesta E. Con CD4 bajo 100, la diarrea crónica acuosa sugiere protozoos oportunistas (Cryptosporidium, Cystoisospora, Cyclospora), que no se ven en el parasitológico habitual y requieren tinción de Ziehl-Neelsen modificada. El tratamiento clave es iniciar TARV. Si el estudio es negativo, sigue la colonoscopía con biopsias buscando citomegalovirus o micobacterias.

▶ VER CLASE 1.06.1.013 Disfagia

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.3 · Disfagia y Trastornos Motores del Esófago

QUÉ HAY QUE SABER

- Disfagia lógica (sólidos → líquidos, progresiva): obstrucción; con baja de peso, cáncer de esófago hasta demostrar lo contrario (escamoso en fumador/alcohólico, adenocarcinoma en ERGE/Barrett).
- Disfagia ilógica (líquidos desde el inicio, fluctuante): trastorno motor, como acalasia (regurgitación no ácida, neumonías aspirativas) o esclerodermia (pirosis grave + Raynaud).
- Disfagia alta con halitosis y regurgitación de comida no digerida: divertículo de Zenker (esofagograma con bario).
- Examen de elección según patrón: lógica → endoscopía con biopsia; ilógica → manometría (acalasia: EEI que no relaja; esofagograma 'pico de pájaro').
- Manejo inicial: asegurar nutrición e hidratación, evaluar riesgo de aspiración; disfagia orofaríngea en ACV: evaluar deglución antes de dar alimento.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología/cirugía; acalasia se trata con miotomía del EEI.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 22

Paciente de 80 años, con antecedente de hipertensión, diabetes insulinodependiente con mal control metabólico y epigastralgia en tratamiento crónico con omeprazol, consulta por cuadro de disfagia lógica asociado a odinofagia de un mes de evolución. Al examen físico no se encuentran alteraciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Cáncer esofágico

B Reflujo gastroesofágico

C Acalasia

D Candidiasis esofágica

E Divertículo esofágico

Respuesta A. La disfagia es lógica, y eso ya apunta a una obstrucción que crece, no a un trastorno motor: cae la acalasia. El uso crónico de omeprazol sugiere un reflujo de base, y a los ochenta años, con este patrón progresivo, hay que descartar cáncer de esófago antes que quedarse con el reflujo. La candidiasis esofágica es el distractor, porque el paciente es diabético mal controlado y tiene odinofagia, pero no da una disfagia lógica progresiva como esta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 112

Un paciente de 80 años consulta por dificultades para comer, caracterizada por disfagia alta intermitente, tanto para alimentos sólidos como líquidos. Refiere, además, regurgitación frecuente de alimentos, halitosis y una pérdida de peso de 4 kg en los últimos meses. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Acalasia esofágica

B Cáncer de esófago

C Divertículo de Zenker

D Esclerosis sistémica con compromiso esofágico

E Reflujo gastroesofágico

Respuesta C. La disfagia es alta, no baja, y viene con halitosis marcada porque el alimento retenido en el saco fermenta: divertículo de Zenker. El distractor es la acalasia, que también da disfagia ilógica y regurgitación de comida sin digerir, pero es baja y no explica una halitosis tan marcada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 38

Una paciente de 56 años, con antecedente de haber vivido en Brasil hasta hace 6 meses, consulta por disfagia lógica y progresiva, asociada a baja de peso de 6 kilogramos. Su examen físico no tiene alteraciones. Tiene antecedente de pirosis y regurgitación de larga data. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Cáncer de esófago
B Estenosis péptica
C Esofagitis eosinofílica
D Acalasia esofágica
E Cáncer gástrico

Respuesta A. El antecedente de vivir en Brasil sugiere Chagas, que también da un trastorno motor esofágico, pero la clínica es de disfagia lógica: progresiva, primero sólidos y luego líquidos. Chagas, esclerodermia y acalasia suelen dar disfagia ilógica. El patrón manda sobre el antecedente epidemiológico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 150

Hombre de 70 años, desdentado, con disfagia alta para sólidos de inicio súbito tras comer. En la endoscopía se encuentra un cuerpo extraño, un trozo de carne, impactado en el esófago superior, y ya se realizó la endoscopía de extracción, con éxito. **¿Cuál es el estudio de seguimiento más importante?**

A Nueva endoscopía para evaluar la mucosa esofágica subyacente y descartar estenosis o tumor
B Radiografía de tórax de control
C TAC de cuello y tórax
D Alta directa sin más estudio
E Esofagografía con bario

Respuesta A. Toda impactación de alimento en el esófago, sobre todo en el adulto mayor, obliga a estudiar el esófago después de resuelto el episodio: puede haber una estenosis péptica, un anillo de Schatzki o incluso un tumor detrás. El estudio es una nueva endoscopía, que ve la mucosa directamente y permite biopsiar si hace falta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 43

Un paciente de 70 años consulta por dificultad para tragar de 2 años de evolución, que se presenta tanto al ingerir alimentos sólidos como líquidos. Además, presenta pirosis y regurgitación frecuente postprandial. Ha bajado un total de 20 kilogramos desde el inicio de sus síntomas y su IMC actual es de 22,2. Al examen físico, tiene un abdomen excavado, sin palpación de masas, con ruidos hidroaéreos presentes y sin signos peritoneales. El resto de su examen físico no aporta mayor información. Se solicitan radiografías contrastadas de esófago, estómago y duodeno, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Síndrome pilórico
B Acalasia esofágica
C Esclerodermia sistémica
D Cáncer gástrico
E Divertículo esofágico

Respuesta B. Disfagia en Adulto Mayor: Aunque la disfagia en un adulto mayor puede indicar cáncer de esófago, en este caso se observa una disfagia ilógica que afecta tanto a sólidos como a líquidos. La radiografía muestra la imagen clásica de acalasia esofágica con obstrucción distal y sin irregularidades en la pared del esófago, a diferencia del cáncer.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 145

Una mujer de 30 años consulta por disfagia ilógica intermitente, asociada a pirosis, regurgitación de alimentos y en ocasiones, dolor retroesternal. Es usuaria de omeprazol, de manera intermitent

E Su examen físico muestra signos vitales normales y el examen abdominal también es normal. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en esta paciente?
A Manometría esofágica
B Radiografías contrastadas de esófago, estómago y duodeno
C Monitorización de pH esofágico de 24 horas
D TAC de abdomen y pelvis

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Manometría esofágica). Clase sobre disfagia (dificultad para tragar), diferenciando la disfagia lógica (progresiva, primero sólidos luego líquidos, obstrucción, típica del cáncer de esófago) de la ilógica (fluctuante, afecta líquidos desde el inicio, trastorno motor, típica de acalasia y esclerodermia).

▶ VER CLASE **1.06.1.014** **Dispepsia** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.2 · Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori

QUÉ HAY QUE SABER

- Dolor o ardor epigástrico, plenitud postprandial o saciedad precoz. Causas: úlcera péptica, AINE, cáncer gástrico y dispepsia funcional (la más frecuente).
- Endoscopía con biopsias de entrada si tiene ≥40 años o signos de alarma (baja de peso, anemia, vómitos, hemorragia, disfagia), por riesgo de cáncer gástrico (GES).
- Menor de 40 sin alarma: buscar H. pylori (test de aire espirado o antígeno fecal) y erradicar si es positivo, o prueba con IBP 4–8 semanas.
- Erradicación de primera línea: IBP + amoxicilina 1 g + claritromicina 500 mg c/12 h por 14 días; si falla, cuádruple con bismuto.
- Dispepsia funcional (endoscopía normal): IBP, proquinéticos o antidepresivos tricíclicos en dosis bajas; suspender AINE, tabaco y alcohol.

- Seguimiento completo en APS; endoscopía si persisten los síntomas o aparecen signos de alarma.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 160

Mujer de 74 años con epigastralgia de 3 semanas de evolución, sin irradiación y sin baja de peso. Tiene antecedente de dispepsia tratada hace 10 años, y usa antiinflamatorios no esteroidales de forma ocasional. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Endoscopía digestiva alta para descartar lesión orgánica, por criterio de alarma según la edad

B Iniciar inhibidor de la bomba de protones y controlar en 4 semanas

C Test no invasivo de Helicobacter pylori y tratar si es positivo

D Radiografía de abdomen

E Ecografía abdominal

Respuesta A. La dispepsia en un mayor de 60 años es, por sí sola, un signo de alarma por la edad: obliga a endoscopía digestiva alta para descartar cáncer gástrico, úlcera péptica u otra lesión orgánica, sin ensayar antes tratamiento empírico. No es necesario que además haya baja de peso u otro signo de alarma.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 70

Paciente de 28 años, con cuadro de 2 meses de dolor epigástrico urente, que aumenta en ayuno y al beber café, asociado a pirosis y reflujo ocasional. Al examen físico no se aprecian alteraciones. La conducta más adecuada en este caso es:

A Iniciar omeprazol

B Iniciar amoxicilina y claritromicina

C Solicitar ecografía

D Solicitar test de ureasa

E Solicitar endoscopía digestiva alta

Respuesta E. Puede ser una úlcera u otra cosa, pero las epigastralgias se estudian con EDA. Que aumente con el café y con ayuno orienta a úlcera.

▶ VER CLASE 1.06.1.015 Enfermedad celiaca

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.3 · Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Enteropatía inmune al gluten (trigo, cebada, centeno). Clínica: malabsorción, distensión, o formas oligosintomáticas; dermatitis herpetiforme.
- Pensar en anemia ferropénica refractaria (con o sin diarrea), osteoporosis precoz, hipertransaminasemia, DM1 o tiroiditis autoinmune.
- Diagnóstico comiendo gluten: anti-transglutaminasa IgA (con IgA total, por falso negativo en déficit de IgA) y biopsia duodenal (atrofia vellositaria, hiperplasia de criptas, linfocitos intraepiteliales).
- Tratamiento: dieta sin gluten estricta y de por vida; corregir déficits (hierro, folato, calcio, vitamina D) y densitometría.
- Seguimiento: anticuerpos negativos habitualmente al año; si no responde, la causa más frecuente es la transgresión (contaminación cruzada); con anticuerpos negativos y malabsorción persistente, sospechar linfoma T de enteropatía.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 60

Ca normal PTH elevada vitamina D baja P bajo, calcio urinario bajo + anemia Ferritina 5. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hiperparatiroidismo primario

B Hiperparatiroidismo Terciario

C Enfermedad celiaca

D Osteoporosis

E Ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta C. Calcio normal, PTH alta, P bajo y vitamina D baja: hiperparatiroidismo secundario por déficit de vitamina D. La ferropenia severa asociada orienta a malabsorción: enfermedad celíaca.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 25

Una paciente de 24 años presenta un cuadro de amenorrea y baja de peso, asociado a náuseas y dolor abdominal de varios meses de evolución. Tiene antecedente de una hermana gemela con hipotiroidismo. Sus exámenes muestran hematocrito de 28 %, blancos 9.600 por mm3, plaquetas 340.000 por mm3, bilirrubina 1,1 mg/dL, GOT 155 UI/L y GPT 120 UI/L. **¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?**

A Solicitar IgM para virus hepatitis A

B Realizar biopsia hepática

C Solicitar colonoscopía

D Solicitar ecografía abdominal

E Solicitar anticuerpos antitransglutaminasa

Respuesta E. Amenorrea, baja de peso, dolor abdominal y anemia en una mujer joven con antecedente familiar de enfermedad autoinmune (hipotiroidismo) orientan a enfermedad celíaca, que puede oligosintomática y elevar discretamente las transaminasas. El estudio inicial son los anticuerpos antitransglutaminasa; la hepatitis es un distractor que no explica el resto del cuadro.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 98

Una paciente de 30 años, con antecedente de hipotiroidismo en tratamiento, consulta por diarrea de 3 meses de evolución, no disentérica, asociada a baja de peso y artralgias. Al examen físico destacan lesiones pruriginosas y vesiculares en el tronco y las extremidades. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Colitis ulcerosa
B Enfermedad celíaca
C Enfermedad de Crohn
D Lupus eritematoso sistémico
E Trastorno digestivo funcional

Respuesta B. La diarrea crónica con baja de peso es compatible con celíaca, Crohn o colitis ulcerosa, pero las lesiones cutáneas pruriginosas y vesiculares son una dermatitis herpetiforme, que se asocia específicamente a la enfermedad celíaca; las enfermedades inflamatorias intestinales dan eritema nodoso o pioderma gangrenoso, no este tipo de lesión.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 111

Una paciente de 23 años, vegetariana estricta, consulta por diarrea de algunos meses de evolución, asociada a baja de peso. Además, trae exámenes, entre los que destaca anemia microcítica e hipoalbuminemia. Su examen físico no aporta mayor información. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Parasitosis intestinal
B Enfermedad celíaca
C Colitis ulcerosa
D Enfermedad de Cröhn
E Enteropatía perdedora de proteínas

Respuesta B. Diarrea crónica, baja de peso, anemia microcítica e hipoalbuminemia: malabsorción. La ferropenia por falla de absorción duodenal sugiere enfermedad celíaca. Ser vegetariana aumenta el riesgo de déficit de B12, que daría macrocitosis, no microcitosis.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 30 años con diarrea crónica, distensión y baja de 6 kg en un año. Tiene una anemia ferropénica que no ha respondido a 4 meses de hierro oral bien tolerado. El test de D-xilosa resulta alterado. **¿Cuál es el siguiente paso más adecuado?**

A Anticuerpos anti-transglutaminasa IgA con IgA total, manteniendo el gluten
B Iniciar dieta sin gluten y controlar en 3 meses
C Medir elastasa fecal por sospecha de insuficiencia pancreática
D Test de hidrógeno espirado
E Cambiar a hierro endovenoso

Respuesta A. D-xilosa alterada = problema de la pared. Con anemia ferropénica refractaria, la primera sospecha es celíaca (el duodeno, donde se absorbe el hierro, es la zona más afectada). Se piden anti-transglutaminasa IgA con IgA total, y luego biopsia duodenal, con el paciente consumiendo gluten.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Paciente con enfermedad celíaca que lleva 1 año con dieta sin gluten. Refiere seguirla de forma estricta, pero persiste con diarrea y baja de peso. Los anticuerpos anti-transglutaminasa están negativos. **¿Cuál es la sospecha diagnóstica?**

A Transgresión oculta de la dieta
B Linfoma T asociado a enteropatía (linfoma MALT)
C Intolerancia a la lactosa secundaria
D Síndrome de intestino irritable sobreagregado
E Giardiasis crónica

Respuesta B. La causa más frecuente de falta de respuesta es la transgresión, pero en ese caso los anticuerpos suelen seguir elevados. Con anticuerpos negativos (buena adherencia) y malabsorción persistente, hay que descartar un linfoma T asociado a enteropatía, con imágenes y biopsias repetidas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 73

Paciente con hipotiroidismo, diarrea acuosa de meses y palidez. ¿Diagnóstico más probable?

A Enfermedad celíaca
B Colitis microscópica
C Hipotiroidismo como causa directa de diarrea
D Síndrome de intestino irritable
E Gastroenteritis crónica eosinofílica

Respuesta A. Diagnóstico: Enfermedad celíaca (opción A). Enfermedad celíaca. Clase sobre el síndrome de malabsorción intestinal, enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa y galactosemia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 125

Una paciente de 18 años, diabética tipo 1 en tratamiento con insulina glargina e insulina cristalina en esquema intensificado, consulta por un cuadro, que inició hace 2 meses, caracterizado por deposiciones líquidas frecuentes, sin mucosidad, asociadas a malestar abdominal y baja de peso de 4 kilogramos. Al examen físico, se aprecia pálida, tiene signos vitales normales y su abdomen es blando, depresible, sensible a la palpación profunda, sin irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes a la auscultación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Enfermedad celíaca

B Síndrome de intestino irritable, asociado a diarrea

C Enteropatía perdedora de proteínas

D Enfermedad inflamatoria intestinal

E Diarrea viral

Respuesta A. Diagnóstico: Enfermedad celíaca (opción A). Clase sobre el síndrome de malabsorción intestinal, enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa y galactosemia.

▶ VER CLASE 1.06.1.016 Enfermedad diverticular complicada

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 5.1 · Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Diverticulitis: adulto mayor con dolor en fosa ilíaca izquierda de días, fiebre, masa palpable y cambio del hábito ('apendicitis izquierda').
- Diagnóstico y etapificación con TAC de abdomen y pelvis con contraste (Hinchey). Colonoscopía contraindicada en el episodio agudo.
- Hinchey I–II (flemón o absceso): antibióticos (ciprofloxacino + metronidazol VO o ceftriaxona + metronidazol EV) y drenaje percutáneo si el absceso mide ≥4 cm.
- Hinchey III–IV (peritonitis purulenta o fecal): cirugía de urgencia, operación de Hartmann.
- Otras complicaciones: fístula colovesical (neumaturia, ITU recurrente), obstrucción, hemorragia digestiva baja masiva.
- Seguimiento: derivar a cirugía; colonoscopía a las 6–8 semanas para descartar cáncer.

PREGUNTAS · 10

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 34

Un paciente se realiza una colonoscopía para la resección de unos pólipos intestinales. Algunas horas después presenta dolor abdominal bajo, asociado a hematoquezia escasa y malestar general. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa ilíaca izquierda. **¿Qué examen es el más adecuado para proseguir con el estudio en este paciente?**

A Resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis

B Ecografía abdominal y pélvica

C Colonoscopía

D Radiografía de abdomen y pelvis

E TAC de abdomen y pelvis

Respuesta E. Diverticulitis aguda post-colonoscópica: el dolor en la fosa ilíaca izquierda que aparece horas después de una colonoscopía con manipulación de pólipos orienta a una perforación diverticular iatrogénica. El TAC de abdomen y pelvis es el examen de elección; repetir la colonoscopía está absolutamente contraindicado en este contexto agudo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 169

Un paciente de 68 años consulta por dolor abdominal bajo, asociado a fiebre, mayor en el cuadrante inferior izquierdo. Temperatura 37,7 grados, frecuencia cardíaca 94, presión arterial 110/76. Abdomen doloroso a la palpación, con marcada resistencia muscular en la fosa ilíaca izquierda y disminución de los ruidos hidroaéreos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Diverticulitis aguda

B Colitis isquémica

C Apendicitis aguda

D Vólvulo de sigmoides

E Cáncer de colon complicado

Respuesta A. Dolor y fiebre localizados en la fosa ilíaca izquierda, con resistencia muscular y ruidos hidroaéreos disminuidos por el íleo reflejo local, en un adulto mayor: presentación clásica de diverticulitis aguda, la "apendicitis izquierda".

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 33

Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, consulta por disminución progresiva de la agudeza visual del ojo derecho. En su evaluación, tiene agudeza visual 20/20 en el ojo izquierdo y 15/20 en el ojo derecho. Su rojo pupilar demuestra una opacidad central con forma de estrella. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Retinopatía diabética

B Edema macular

C Catarata

D Glaucoma

E Hemorragia vítrea

Respuesta C. Disminución progresiva de la agudeza visual con una opacidad en el rojo pupilar: catarata. La retinopatía diabética no da síntomas hasta sus complicaciones; el edema macular no altera el rojo pupilar; la hemorragia vítrea es súbita y lo abole por completo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 171

Una paciente de 70 años, al tercer día después de una colonoscopía con resección de un pólipo, acude al servicio de urgencia por dolor abdominal muy intenso, en la zona inferior izquierda, asociada a sensación febril y deposiciones con sangre, en una oportunidad. Al examen físico tiene abdomen doloroso a la palpación profunda, mayor en la fosa ilíaca izquierda y signo de Blumberg en dicha zona. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de esta paciente?**

A Radiografía de abdomen simple

B Ecotomografía abdominal

C Tomografía axial computada de abdomen y pelvis

D Resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis

E Colonoscopía

Respuesta C. Dolor en la fosa ilíaca izquierda con fiebre y Blumberg en una paciente mayor: el examen que continúa el estudio es el TAC de abdomen y pelvis, para caracterizar la diverticulitis y clasificarla por Hinchey. La colonoscopía queda contraindicada en el episodio agudo por el riesgo de perforar un colon ya inflamado.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 63 años con diverticulitis aguda. El TAC muestra abundante líquido y aire libre intraperitoneal, con signos de peritonitis fecal difusa. Está febril, taquicárdica e hipotensa. **¿Cuál es la conducta?**

A Antibióticos endovenosos y reevaluar en 48 horas

B Drenaje percutáneo guiado por TAC

C Cirugía de urgencia (operación de Hartmann)

D Colonoscopía para localizar la perforación

E Resección sigmoidea laparoscópica con anastomosis primaria diferida

Respuesta C. Aire y líquido libre con peritonitis fecal: Hinchey IV. Junto con el Hinchey III es indicación de cirugía de urgencia: resección del sigmoides con colostomía terminal y cierre del muñón rectal (Hartmann). El manejo médico o percutáneo solo sirve en los abscesos (Hinchey I–II).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 110

Una paciente de 60 años consulta por dolor abdominal de 24 horas de evolución, mayor en la fosa ilíaca izquierda, que se ha asociado a tres episodios de diarrea acuosa sin sangre. Al examen físico, sus signos vitales muestran presión arterial 132/85 mmHg, frecuencia cardíaca 85 por minuto y temperatura 37,5 °C. En la exploración abdominal presenta dolor a la palpación abdominal, especialmente intenso en la fosa ilíaca izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Gastroenteri2s aguda

B Diver2culi2s aguda

C Apendici2s aguda

D Endometri2s aguda

E Coli2s isquémica

Respuesta B. Es una diverticulitis aguda clásica. Se estudia con TAC. El manejo depende de la clasificación de Hinchey: - Ia (flegmón/inflamación pericólica): antibióticos VO. - Ib (absceso pericólico < 5 cm): antibióticos VO o EV. - II (absceso distante o > 5 cm): drenaje x punción + antibióticos EV. - III (peritonitis purulenta generalizada): cirugía (ej. Hartmann). - IV (peritonitis fecaloidea): cirugía (Hartmann).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 57

Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes e hipertensión, en tratamiento con metformina, glibenclamida y enalapril, consulta por dolor abdominal, de 2 días evolución, mayor en el flanco izquierdo y en la fosa iliaca izquierda, asociado a sensación febril. Al examen físico presenta T°: 38°C, PA: 100/60 mmHg, FC: 88x', abdomen doloroso a la palpación, mayor en la zona, con signos peritoneales localizados en dicha área y disminución de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Infarto del ciego
B Trombosis venosa mesentérica
C Colitis isquémica
D Obstrucción intestinal
E Diverticulitis aguda

Respuesta E. Diagnóstico: Diverticulitis aguda (opción E). Es una diverticulitis clásica. El cuadro clínico de dolor localizado en fosa ilíaca izquierda ("apendicitis izquierda"), fiebre y leucocitosis en un paciente adulto mayor o con constipación crónica configura la presentación clásica de diverticulitis aguda (enfermedad diverticular complicada). El examen confirmatorio de elección es la tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen y pelvis con contraste.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 91

Una paciente de 60 años presenta dolor abdominal de 2 días de evolución, mayor en el abdomen bajo. Al examen físico tiene dolor a la palpación abdominal, especialmente en la fosa iliaca izquierda, con signo de Blumberg positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Enfermedad inflamatoria pélvica
B Diverticulitis aguda
C Colitis isquémica
D Apendicitis aguda
E Enfermedad de Cröhn

Respuesta B. Diagnóstico: Diverticulitis aguda (opción B). Es una diverticulitis aguda clásica. El cuadro clínico de dolor localizado en fosa ilíaca izquierda ("apendicitis izquierda"), fiebre y leucocitosis en un paciente adulto mayor o con constipación crónica configura la presentación clásica de diverticulitis aguda (enfermedad diverticular complicada). El examen confirmatorio de elección es la tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen y pelvis con contraste.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 157

Mujer de 88 años de edad, quien presenta clínica un día de evolución caracterizada por fiebre, diarrea y dolor en hipogastrio. Refiere evacuaciones sin otras alteraciones. Al examen físico presenta temperatura en 38,5 grados, presión arterial de 90/50 mmHg y al examen abdominal presenta dolor y sensibilidad a la palpación en fosa ilíaca izquierda, sin signos de irritación peritoneal. El diagnóstico más probable es:

A Diverticulitis aguda
B Colitis isquémica
C Pielonefritis aguda
D Enfermedad inflamatoria intestinal
E Rectocolitis bacteriana

Respuesta A. Es una diverticulitis aguda clásica, aunque aún no tenga signos peritoneales. El dolor en la FII y la fiebre lo sugieren fuertemente. Por el buen estado general, seguro es Hinchey I.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 130

Una paciente de 70 años acude por cuadro clínico de doce horas de evolución caracterizada por dolor en hemiabdomen inferior, que ha ido en aumento, siendo mayor en el hemiabdomen izquierdo. Al examen físico, presenta frecuencia cardíaca de 96 lpm, PA: 90/60 mmHg, temperatura 38,5 grados, sudoración y palidez, y examen abdominal con abdomen doloroso a la palpación, con Blumberg (+) y signos de irritación peritoneal en la fosa iliaca izquierda. El diagnóstico más probable es:

A Diverticulitis aguda
B Cáncer colorectal complicado
C Vólvulo sigmoideo
D Obstrucción intestinal
E Cáncer de ovario complicado

Respuesta A. Diagnóstico: Diverticulitis aguda (opción A). Es una diverticulitis clásica, con irritación peritoneal en la FII (fosa iliaca izquierda). El cuadro clínico de dolor localizado en fosa ilíaca izquierda ("apendicitis izquierda"), fiebre y leucocitosis en un paciente adulto mayor o con constipación crónica configura la presentación clásica de diverticulitis aguda (enfermedad diverticular complicada). El examen confirmatorio de elección es la tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen y pelvis con contraste.

▶ VER CLASE 1.06.1.017 Enfermedad diverticular no complicada

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.3 · Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx

QUÉ HAY QUE SABER

- Diverticulosis: herniaciones de la mucosa en puntos débiles del sigmoides; muy frecuente en adultos mayores y casi siempre asintomática (hallazgo en colonoscopía).
- Factores de riesgo: dieta baja en fibra, carnes rojas y grasas, obesidad, tabaco, AINE.

- Diverticulitis aguda no complicada (Hinchey 0–Ia): dolor en fosa ilíaca izquierda con fiebre; manejo ambulatorio si es joven, estable y tolera la vía oral (ciprofloxacino + metronidazol 7–10 días).
- Hospitalizar si hay comorbilidad, inmunosupresión o mala tolerancia oral; repetir TAC si no mejora en 48–72 h.
- Prevención de recurrencias: dieta rica en fibra, actividad física y bajar de peso.
- Seguimiento completo: colonoscopía a las 6–8 semanas tras un episodio de diverticulitis para descartar cáncer.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 62 años, asintomática, se realiza colonoscopía de tamizaje que muestra múltiples divertículos en el colon sigmoides, sin signos inflamatorios ni pólipos. Nunca ha tenido dolor abdominal ni sangrado. **¿Cuál es la recomendación más adecuada?**

A Mesalazina oral de mantención

B Evitar semillas, nueces y maíz

C Dieta rica en fibra y actividad física

D Ciprofloxacino y metronidazol en ciclos mensuales

E Sigmoidectomía electiva

Respuesta C. La diverticulosis asintomática no requiere tratamiento específico: se recomienda dieta rica en fibra, actividad física y evitar tabaquismo y obesidad. La restricción de semillas y nueces no tiene respaldo. Mesalazina y antibióticos cíclicos no previenen la diverticulitis, y la cirugía electiva no está indicada en la enfermedad no complicada.

▶ VER CLASE 1.06.1.018 Enfermedad inflamatoria intestinal

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Gastroenterología 2.4 · Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn
Reumatología 9.18 · Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en adulto joven con diarrea crónica con sangre, mucosidad o pus en brotes, dolor abdominal, fiebre y baja de peso.
- Colitis ulcerosa: solo colon, continua desde el recto, mucosa; Crohn: boca a ano (típico íleon terminal), en parches, transmural, con fístulas y enfermedad perianal. Basta una característica de Crohn para clasificarla como Crohn.
- Manifestaciones extraintestinales: artritis periférica (curso paralelo al intestino), espondilitis, uveítis, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, colangitis esclerosante primaria (CU).
- Estudio: calprotectina fecal, colonoscopía total con ileoscopía y biopsias; descartar infecciones (coprocultivo, C. difficile). p-ANCA (CU) y ASCA (Crohn) solo apoyan.
- Manejo inicial: hidratación; complicaciones graves (megacolon tóxico >6 cm + sepsis, obstrucción, absceso) se hospitalizan. Corticoides solo para el brote, nunca de mantención.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología (5-ASA, inmunomoduladores, biológicos; vigilancia de cáncer colorrectal tras 8–10 años).

PREGUNTAS · 23

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 176

Un paciente de 31 años consulta por 2 meses de evolución de dolor abdominal y deposiciones diarreicas, inicialmente 3 veces al día, con aumento a 7 veces al día en las últimas 2 semanas. Examen físico: FC 88 por minuto, PA 130/82, T° 36,0 °C, abdomen blando, depresible, con meteorismo, sin masas ni visceromegalias, con ruidos hidroaéreos presentes y sin signos de irritación peritoneal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Enfermedad de Crohn

B Enfermedad celíaca

C Colitis ulcerosa

D Colitis parasitaria

E Síndrome de intestino irritable

Respuesta C. Diarrea crónica que empeora recientemente, subiendo de 3 a 7 deposiciones diarias en 2 semanas: es un cambio reciente del patrón, señal de alarma (la "C" de ABCDEFH) que descarta el intestino irritable y obliga a estudio orgánico; con esa evolución, la colitis ulcerosa es el diagnóstico más probable.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 26

Hombre de 25 años con 1 mes de diarrea, dolor abdominal y malestar general; ha tenido disentería en algunas ocasiones y bajó 4 kg. La colonoscopía muestra signos de inflamación en el colon, con zonas de mucosa indemne y sin afectación del recto. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Colitis ulcerosa

B Enfermedad de Crohn

C Colitis isquémica

D Parasitosis intestinal

E Colitis por Clostridioides difficile

Respuesta B. La colonoscopía define el caso: inflamación en parches, con zonas de mucosa indemne, y respeto del recto. Cualquiera de esas dos características, por sí sola, descarta la colitis ulcerosa, que es continua y siempre rectal, y establece el diagnóstico de enfermedad de Crohn.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 21

Paciente de 45 años con colitis ulcerosa diagnosticada a los 20 años, inactiva hace 10 años. Desde hace una semana presenta deposiciones blandas con escasa sangre. El examen físico no aporta información. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar rectosigmoidoscopía

B Solicitar TAC de abdomen y pelvis

C Solicitar parasitológico de deposiciones

D Solicitar colonoscopía

E Iniciar corticoides orales

Respuesta D. La CU de larga data aumenta el riesgo de cáncer colorrectal, sobre todo rectal, y todo sangrado digestivo bajo nuevo en un adulto exige colonoscopía completa: la rectosigmoidoscopía no explora el colon proximal. No se asume un brote ni se inician corticoides antes de descartar neoplasia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 164

Mujer de 35 años con diarrea crónica mucosanguinolenta de 6 meses, urgencia defecatoria, pujo y tenesmo. Colonoscopía: mucosa eritematosa, granular, con pseudopólipos, desde el recto en forma continua hasta el ángulo esplénico, sin mucosa sana intercalada. **¿Cuál es el diagnóstico?**

A Colitis isquémica

B Colitis ulcerosa

C Síndrome de intestino irritable

D Colitis infecciosa

E Enfermedad de Crohn

Respuesta B. Compromiso mucoso continuo desde el recto hacia proximal, sin mucosa sana intercalada, con pseudopólipos y clínica de pujo y tenesmo: es una colitis ulcerosa. La ausencia de parches, de compromiso ileal y de lesiones perianales descarta el Crohn.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2021 · PREGUNTA 20

Mujer de 32 años con antecedente de Colitis Ulcerosa de 4 años de evolución presenta un brote intestinal agudo con diarrea sanguinolenta (6 deposiciones al día con pujo y tenesmo). De forma simultánea inicia dolor y derrame articular en rodilla derecha y tobillo izquierdo. ¿Cuál es el comportamiento clínico esperado de esta artritis periférica con relación a la evolución de su enfermedad intestinal?

A La artritis progresará de forma independiente requiriendo cirugía protésica precoz

B La artritis remitirá completamente al resolverse el brote inflamatorio de la colitis

C La artritis transformará la enfermedad en espondilitis anquilosante irreversible

D La artritis indica degeneración neoplásica colónica maligna inmediata

E La artritis persistirá de forma crónica sin responder a corticoides

Respuesta B. La artropatía periférica asociada a Enfermedad Inflamatoria Intestinal de tipo pauciarticular (Tipo 1, que afecta rodillas y tobillos en menos de 5 articulaciones) sigue un curso estrictamente paralelo a la actividad de la mucosa colónica. Al tratar el brote de colitis ulcerosa con corticoides o aminosalicilatos y remitir la inflamación intestinal, la artritis periférica cede de forma completa sin dejar daño articular residual.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 25 años con 3 meses de diarrea con sangre y mucosidad, dolor abdominal, fiebre vespertina y baja de 5 kg. Al examen: masa dolorosa mal definida en la fosa ilíaca derecha y una úlcera aftosa en la mucosa oral. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Colitis ulcerosa

B Síndrome de intestino irritable

C Enfermedad de Crohn

D Cáncer de colon derecho

E Colitis infecciosa aguda

Respuesta C. Diarrea disentérica crónica con síntomas sistémicos en un joven: EII. La masa en fosa ilíaca derecha (plastrón ileal) y las aftas orales son características de Crohn; basta una. La CU es solo colónica, continua y mucosa: no da masa ni compromiso ileal. Conducta: colonoscopía con ileoscopía y biopsias.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 163

Joven de 25 años con diarrea crónica de 8 meses, 5-6 deposiciones al día sin sangre, pérdida de peso de 7 kg, úlceras orales recurrentes, dolor abdominal periumbilical y fístula perianal. Colonoscopía: úlceras aftosas con mucosa normal entre ellas (patrón en empedrado). ¿Cuál es el diagnóstico?

A Síndrome de intestino irritable

B Colitis ulcerosa

C Enfermedad de Crohn

D Tuberculosis intestinal

E Linfoma intestinal

Respuesta C. Enfermedad de Crohn: compromiso transmural + patrón en empedrado + úlceras aftosas con mucosa intercalada normal + fístula perianal + úlceras orales + localización que puede ser cualquier tramo del tubo digestivo. La CU no tiene fístulas ni compromiso ileal típico ni úlceras orales.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 110

Un paciente de 25 años presenta un cuadro de 3 semanas de dolor abdominal tipo cólico y diarrea acuosa, que en ocasiones es sanguinolenta. Además, ha presentado úlceras orales recidivantes y ha bajado de peso. Al examen físico tiene abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación profunda y sin signos de irritación peritoneal y con ruidos hidroaéreos conservados. Hace 4 semanas se realizó manejo quirúrgico de una fístula anorrectal. El diagnóstico más probable es:

A Colitis parasitaria

B Enfermedad de Cröhn

C Enfermedad celíaca

D Colitis ulcerosa

E Colitis pseudomembranosa

Respuesta B. Tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. Las úlceras orales se ven tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Cróhn. La fístula anorrectal orienta fuertemente a enfermedad de Cróhn.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 16

Un paciente de 35 años consulta por un cuadro de dolor abdominal y diarrea de 3 meses de evolución, con 8 a 10 deposiciones líquidas al día, tanto diurnas como nocturnas. Presenta dolor abdominal tipo cólico con exacerbación en el hemiabdomen derecho. Además, al interrogatorio, refiere visión borrosa con enrojecimiento del ojo derecho y ajas orales recurrentes. También, relata baja de peso y presencia ocasional de sangre en las deposiciones. Al examen físico se observa pálido, con frecuencia cardíaca 90 lpm, presión arterial 125/72 mmHg y temperatura 37,2 °C. El abdomen está blando y sensible de forma difusa, con dolor más intenso en la fosa ilíaca derecha, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Coli2s ulcerosa

B Coli2s infecciosa

C Cáncer de colon

D Enfermedad de Crohn

E Síndrome de intes2no irritable con predominio de diarrea Mortalidad Mortalidad proporcional Mortalidad Mortalidad proporcional Patología cardiovascular 60/1000 50% 150/1000 71,4% Cáncer 30/1000 25% 30/1000 14,3% Otras causas de muerte 30/1000 25% 30/1000 14,3% Total 120/1000 100% 210/1000 100% Periodo inicial Periodo tardío

Respuesta D. Tiene clínica de una enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Entre ellas, parece más enfermedad de Crohn, por el dolor en el lado derecho (la zona ileocecal es lo más frecuentemente afectado), las amas (el compromiso oral también se puede ver en la colitis ulcerosa, pero orienta a Crohn) y el compromiso ocular (más frecuente en enfermedad de Crohn que en colitis ulcerosa).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 103

Un hombre de 26 años consulta por dolor abdominal de 3 meses de evolución, asociado a diarrea acuosa, que en ocasiones ha presentado hematoquecia. Hace una semana se agrega marcado pujo y tenesmo, más aumento de la intensidad del dolor abdominal. Al examen físico tiene signos vitales normales y su abdomen es sensible a la palpación, con dolor a la palpación de la fosa iliaca y el flaco izquierdos, sin signos peritoneales. Los ruidos hidroaéreos se auscultan conservados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Enfermedad de Cröhn

B Enfermedad celiaca

C Colitis ulcerosa

D Megacolon amebiano

E Cáncer de colon

Respuesta C. Diagnóstico: Colitis ulcerosa (opción C). Es una colitis ulcerosa clásica. No tiene elementos que hagan elegir a la enfermedad de Cröhn. Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 123

Mujer de 29 años, sin antecedentes, con cuadro de tres semanas de dolor abdominal intermitente, de intensidad moderada, asociado a deposiciones con sangre en ocasiones y disentería. Al examen físico se aprecia levemente deshidratada, con dolor a la palpación abdominal profunda, blumberg (-). El diagnóstico más probable es:

A Colitis ulcerosa

B Giardiasis

C Divertículo de Meckel

D Colitis isquémica

E Enfermedad de Crohn

Respuesta A. Es una EII. No tiene ninguno de los elementos que orientan a Cröhn, por lo que hay que elegir CU. Si tuviera algo de Cröhn (abscesos perianales, malabsorción intestinal, fístulas, úlceras orales, ASCA+, compromiso de intestino delgado, compromiso en parches o discontinuo, masa, perforación, etc) sería Cröhn.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 110

Un paciente de 27 años consulta por dolor abdominal de un mes de evolución, asociado a diarrea y baja de peso de 6 kg. En algún momento, presentó deposiciones sanguinolentas. Se solicita una tomografía axial computarizada (TAC), que muestra engrosamiento del íleon distal y del ciego, sin masas. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio diagnóstico?

A Parasitológico de deposiciones
B Endoscopía digestiva alta
C Colonoscopía
D Enteroscopía
E Enteroclisis por TAC

Respuesta C. Enfermedad de Crohn: La clínica de la paciente es compatible con una enfermedad inflamatoria intestinal. Además, la TAC muestra un compromiso del intestino delgado, lo que sugiere una enfermedad de Crohn. En las enfermedades inflamatorias intestinales, el diagnóstico definitivo se realiza mediante una colonoscopía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 135

Una paciente de 17 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de dolor abdominal tipo cólico, que se ha exacerbado en las últimas 3 semanas y que está asociado a deposiciones diarreicas intermitentes, las que dice haber tenido desde los 15 años, con aumento de la frecuencia en el último mes. Al examen físico presenta inyección ciliar bilateral, sus signos vitales se encuentran dentro de los parámetros normales; al examen abdominal presenta dolor leve a la palpación abdominal sin signos peritoneales y se detecta una masa palpable en el flanco derecho. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 31%, hemoglobina: 10.2 g/dL, VCM: 76 fL, HCM: 27 pg, glóbulos blancos: 10.000 por mm3, plaquetas: 320.000 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Enfermedad de Crohn
B Enfermedad celíaca
C Colitis parasitaria
D Colitis ulcerosa
E Cáncer de colon

Respuesta A. Enfermedad de Cröhn: El cuadro clínico es compatible con enfermedad inflamatoria intestinal con síntomas extraintestinales (oculares). La presencia de una masa sugiere fuertemente enfermedad de Cröhn. Si hubiese sido un adulto mayor, se hubiese sospechado un cáncer de colon.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 116

Una paciente de 23 años, consulta por un cuadro de diarrea de tres meses de evo- lución asociada a sensación febril y fiebre cuantificada hasta 38,0°C. Además, ha pre- sentado disentería en algunas oportunidades y refiere entre otros síntomas, dolor arti- cular migratorio en las cuatro extremidades. Al examen físico se aprecian aftas orales y nódulos eritematosos dolorosos en la cara anterior de las piernas. Su examen abdomi- nal muestra un abdomen blando, doloroso a la palpación, sin signos peritoneales. El diagnóstico más probable es:

A Enfermedad celiaca
B Infección por salmonella
C Déficit de IgA
D Colitis ulcerosa
E Lupus eritematoso sistémico

Respuesta D. Es una mala pregunta, porque la clínica orienta a enfermedad de Cröhn, que no aparecía en las enfermedades. Solo quedaba marcar la colitis ulcerosa, pero las úlceras orales no son complatibles.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 50

Un hombre de 35 años consulta por deposiciones abundantes y líquidas, que iniciaron hace 2 semanas y se presentan hasta 5 veces al día. Además, refiere malestar general y sensación febril. Dos meses atrás fue operado por una fístula perianal. Al examen físico tiene T°: 37,7°C, FC: 88x', PA. 120/80 mmHg, examen oral con tres úlceras; el examen abdominal muestra abdomen blando, depresible, sensible a la palpación profunda, con negatividad de los signos peritoneales y presencia de ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Infección por Shigella
B Colitis ulcerosa
C Enfermedad de Cröhn
D Colitis pseudomembranosa
E Infección por Entamoeba histolytica

Respuesta C. Diagnóstico: Enfermedad de Cröhn (opción C). Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 81

Paciente joven con diarrea de larga data, sin mucosidad ni sangre, TAC con engrosamiento íleon distal, diagnóstico, *calprotectina fecal elevada (1500 creo): cáncer/Crohn/CU? (Es Crohn) Tenia mas pinta de cancer<—- no porque tenia 20 y tantos. Tenia 48 era viejo. Pero por el nivel de calprotectina y el compromiso de intestino delgado es Crohn...

A Hemograma y VHS
B Ecografía
C Radiografía
D TAC con contraste
E Resonancia magnética

Respuesta A. Diagnóstico: Hemograma y VHS (opción A). Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 27

Un paciente de 23 años presenta dolor abdominal de 2 meses de evolución, asociado a deposiciones acuosas, que han ido en aumento, hasta presentar diarrea varias veces al día. Además ha tenido sensación de fiebre, y ha perdido 3 kilos de peso. Refiere también que en la última semana presentó un cuadro de hematoquezia abundante, con coágulos. ¿Qué examen es el más adecuado para iniciar el estudio de este paciente?

A TAC de abdomen y pelvis
B Colonoscopía
C Coprocultivo y leucocitos fecales
D Examen parasitológico seriado de deposiciones
E Toxinas de Clostridium difficile en deposiciones

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Colonoscopía). Es una enfermedad inflamatoria intestinal, que se estudia con colonoscopía. Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 142

Una paciente de 25 años consulta por diarrea de un mes de evolución, asociada a dolor abdominal tipo cólico y algunos episodios de hematoquecia. Además, tiene artralgias de las manos y rodillas, con artritis de la rodilla derecha. Al examen físico se observan úlceras orales y lesiones nodulares en la cara anterior de las piernas. El examen abdominal muestra abdomen blando sensible, sin masas. El diagnóstico más probable es:

A Lupus eritematosos sistémico
B Enfermedad de Behcet
C Colitis ulcerosa
D Artritis reumatoide
E Colitis por Clostridium difficile

Respuesta C. Si bien las úlceras orales sugieren más una enfermedad de Cröhn que una colitis ulcerosa, el cuadro clínico es compatible con una enfermedad inflamatoria intestinal, con la artritis secundaria y eritema nodoso. El LES sí tiene úlceras orales, pero es rara la afectación digestiva. La enfermedad de Behcet sí tiene úlceras orales y genitales, más artritis, pero con afectación del SNC y SNP y sin afectación digestiva.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 116

Un paciente de 25 años consulta por diarrea, que inició hace 3 meses, que en ocasiones es sanguinolenta. Además presenta pujo y tenesmo frecuente y ha bajado 6 kilogramos de peso. Al examen físico, presenta dolor abdominal a la palpación del flanco izquierdo, ruidos hidroaéreos aumentados y úlceras orales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Solicitar endoscopía digestiva y anticuerpos antitransglutaminasa
B Iniciar antibióticos orales
C Solicitar colonoscopía
D Solicitar ecografía abdominal
E Pedir un TAC de abdomen y pelvis

Respuesta C. Probablemente tiene una enfermedad de Cröhn (por las úlceras orales no es colitis ulcerosa). Se estudia con colonoscopía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 12

Un hombre de 23 años consulta por dolor abdominal de 2 meses de evolución, que ha ido en aumento y se asocia a diarrea acuosa. Al examen físico se palpa abdomen sensible, con ruidos hidroaéreos conservados. Hace 2 días aumenta el dolor y la diarrea, por lo que se solicita una TAC de abdomen y pelvis, que muestra engrosamiento del íleon distal y del ciego, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?

A Endoscopía digestiva alta
B Resonancia magnética de abdomen
C Ecografía abdominal
D Colonoscopía
E Parasitológico de deposiciones y coprocultivo

Respuesta D. No queda claro cuál es el diagnóstico, pero parece una enfermedad de Cröhn, por lo que se estudia con colonoscopía. También podría ser un linfoma MALT, que se estudia igual.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 69

Hombre con diarrea disentérica, aftas bucales y antecedente de fístula perianal tratada. ¿Diagnóstico más probable?

A Colitis ulcerosa
B Síndrome de intestino irritable
C Colitis infecciosa por Shigella
D Enfermedad de Crohn
E Colitis isquémica

Respuesta D. Diagnóstico: Enfermedad de Crohn (opción D). Enfermedad de Crohn. Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 103

Una paciente de 35 años consulta por diarrea de 3 meses de evolución asociada a dolor abdominal, con deposiciones frecuentes de 5 a 6 veces durante el día y 1 a 2 veces en la noche. En ocasiones ha presentado escasos restos de sangre y ha bajado 17 kg de peso desde el inicio de los síntomas. Al examen físico presenta signos vitales normales. Se constata IMC de 41,8 y se palpa abdomen blando, sensible de manera difusa, sin signos peritoneales, masas, ni visceromegalias. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A An2cuerpos an2-transglutaminasa
B Endoscopía diges2va alta
C Ecogra:a abdominal
D Coprocul2vo y parasitológico de deposiciones
E Colonoscopía

Respuesta E. Ya sea que se sospeche una enfermedad inflamatoria intestinal (lo más probable) o un cáncer de colon, se debe estudiar con colonoscopía completa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 127

Una paciente de 27 años consulta por deposiciones diarreicas de 3 semanas de evolución, asociadas a mucho pujo y tenesmo rectal. Refiere rectorragia ocasional escasa. Su examen físico muestra T°: 37°C, PA: 122/78 mmHg, FC: 72x', abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación hipogástrica y fosa iliaca izquierda. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A Test de sangre oculta en deposiciones
B Parasitológico de deposiciones
C Colonoscopía
D Tomografía axial computada de abdomen y pelvis
E PCR para Clostridioides difficile

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Colonoscopía). Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

▶ VER CLASE 1.06.1.019 Hepatitis aguda A no complicada

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.2 · Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Transmisión fecal-oral (agua, alimentos, jardines infantiles); en niños suele ser anictérica. Notificación obligatoria inmediata.
- Clínica: pródromo (fiebre, náuseas, malestar), luego ictericia, coluria y acolia; transaminasas muy elevadas.
- Diagnóstico: IgM anti-VHA, primer examen en toda hepatitis aguda.
- Tratamiento de soporte: reposo relativo, hidratación, evitar alcohol, paracetamol en dosis altas y fármacos hepatotóxicos; no requiere dieta especial.
- Vigilar gravedad con tiempo de protrombina/INR (no con bilirrubina ni transaminasas). Formas atípicas: colestásica, recurrente, fulminante (~0,1 %).
- Seguimiento completo: control clínico y de laboratorio hasta normalizar. Contactos: convivientes inmunoglobulina + vacuna; extradomiciliarios vacuna.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 127

Hombre de 32 años regresa de un viaje a un país vecino. A los pocos días presenta un cuadro de 5 días de fiebre, asociado a malestar general, seguido luego de dolor abdominal, ictericia y orinas oscuras. Al examen físico está ictérico, con dolor a la palpación del hipocondrio derecho. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hepatitis A
B Hepatitis B
C Hepatitis alcohólica
D Coledocolitiasis
E Fiebre tifoidea

Respuesta A. Pródromo febril e inespecífico seguido de ictericia, coluria y dolor en hipocondrio derecho, después de un viaje, es la hepatitis A clásica, de transmisión fecal-oral. Se confirma con IgM anti-VHA y el manejo es de soporte. La hepatitis B tiene una incubación más larga, de 1 a 6 meses, y transmisión parenteral o sexual.

▶ VER CLASE **1.06.1.020** **Hepatitis agudas B, C, por otros virus, por drogas y tóxicas**

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.2 · Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Hepatitis B aguda: AgHBs + con IgM anti-HBc +; período de ventana con AgHBs – e IgM anti-HBc +. En adultos 90 % cura; en RN >90 % cronifica. Fulminante ~1 %.
- Hepatitis C: parenteral (drogas EV, transfusiones antes de 1996); rara vez cuadro agudo, cronifica 80–90 %. Tamizaje anti-VHC y confirmar con ARN-VHC por PCR.
- Hepatitis E: igual a la A, salvo en embarazadas (letalidad de hasta 20 %). Otras virales: CMV, VEB, herpes.
- Alcohólica: AST/ALT >2 (ambas <300–400), GGT y VCM altos; grave (Maddrey) con prednisolona. Fármacos: suspender siempre; paracetamol con N-acetilcisteína; antituberculosos: suspender todos.
- Manejo inicial: soporte y monitoreo de TP/INR; encefalopatía o INR prolongado = hepatitis fulminante, derivar a centro de trasplante. Profilaxis post exposición a VHB: IgHB + vacuna.
- Seguimiento: derivar; B y C crónicas son GES (VHC curable con antivirales de acción directa 8–12 semanas).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 83

Mujer de 20 años en tratamiento con isotretinoína hace 10 días por acné, con dolor abdominal, astenia, ictericia y orinas oscuras. Hígado palpable 3 cm bajo el reborde. GOT 328 U/L, GPT 459 U/L, bilirrubina 1,8 mg/dL, FA 80, GGT 92, protrombinemia 80 %. IgG anti-VHA (+), IgM anti-VHA (–), AgHBs (–), anti-HBc totales (+); anti-VHC y autoinmunidad pendientes. **El diagnóstico más probable es:**

A Hepatitis A
B Hepatitis B
C Hepatitis C
D Hepatitis por fármacos
E Hepatitis autoinmune

Respuesta D. IgM anti-VHA negativa descarta hepatitis A aguda (la IgG solo marca contacto previo). AgHBs negativo descarta infección B activa; anti-HBc sin AgHBs indica exposición pasada. Por descarte y por la relación temporal con isotretinoína: hepatitis por fármacos. Conducta: suspender el fármaco de inmediato.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 52 años, bebedor habitual, consulta por ictericia y dolor en hipocondrio derecho. Al examen: hepatomegalia dolorosa. Laboratorio: AST 260 U/L, ALT 100 U/L, GGT muy elevada, VCM 104 fL. IgM anti-VHA y AgHBs negativos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hepatitis A aguda
B Hepatitis alcohólica
C Esteatohepatitis metabólica (NASH)
D Hepatitis autoinmune
E Hepatitis B en período de ventana

Respuesta B. Ictericia y hepatomegalia dolorosa en un bebedor, con AST/ALT > 2, transaminasas bajo 300–400, GGT y VCM elevados: hepatitis alcohólica. La NASH tiene AST/ALT < 1. El período de ventana requiere IgM anti-HBc positiva, que no se informa.

▶ VER CLASE **1.06.1.021** **Hepatitis crónica**

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.2 · Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Inflamación hepática de más de 6 meses; causas: hígado graso metabólico (la más frecuente), VHB, VHC, alcohol, autoinmune, hemocromatosis, Wilson.
- Hepatitis B crónica: AgHBs + con IgM anti-HBc negativa. Hepatitis C: anti-VHC + confirmado con ARN-VHC por PCR (anticuerpo + con PCR – = infección resuelta).
- Autoinmunes: hepatitis autoinmune (mujer, ANA, ASMA, anti-LKM1; corticoides + azatioprina), colangitis biliar primaria (AMA +, ursodesoxicólico), colangitis esclerosante (colitis ulcerosa, p-ANCA).
- Evaluar fibrosis (elastografía o biopsia): grado = actividad inflamatoria, estadio = fibrosis acumulada; mata lento por cirrosis y hepatocarcinoma.
- Manejo inicial: suspender alcohol, vacunar hepatitis A/B, bajar 7–10 % del peso en NASH, estudiar contactos de VHB.
- Seguimiento: derivar (VHB y VHC crónicas son GES; VHC curable >95 % con antivirales de acción directa); con cirrosis, ecografía semestral.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 38 años con astenia. Sus exámenes muestran GPT 180 U/L y GOT 140 U/L, elevadas en forma persistente por 8 meses, con bilirrubina normal. AgHBs y anticuerpos anti-VHC negativos; no consume alcohol ni fármacos. Tiene IgG sérica elevada y anticuerpos antinucleares y anti-músculo liso positivos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y su tratamiento?**

A Hepatitis C crónica; antivirales de acción directa

B Hepatitis autoinmune; prednisona con o sin azatioprina

C Esteatohepatitis metabólica; baja de peso

D Enfermedad de Wilson; penicilamina

E Hepatitis A prolongada; manejo de soporte

Respuesta B. Hepatitis de más de 6 meses en una mujer, con hipergammaglobulinemia IgG y anticuerpos antinucleares y anti-músculo liso positivos, es una hepatitis autoinmune tipo 1. Se confirma con biopsia hepática y se trata con corticoides, solos o con azatioprina. La serología negativa descarta virus B y C.

▶ VER CLASE 1.06.1.022 Insuficiencia hepática crónica

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.3 · Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Falla de las funciones del hígado en un cirrótico: ictericia, hipoalbuminemia, coagulopatía (INR alto), encefalopatía; asociada a hipertensión portal (ascitis, várices, esplenomegalia).
- Gravedad por Child-Pugh (A/B/C) y MELD (bilirrubina, INR, creatinina, sodio), que define prioridad de trasplante.
- Buscar el factor descompensante: infección (PBE), HDA, alcohol, fármacos, constipación, trastornos electrolíticos, hepatocarcinoma.
- Manejo inicial: tratar la descompensación (lactulosa en encefalopatía, diuréticos y paracentesis en ascitis, antibióticos en PBE); no corregir el INR de rutina, solo si sangra o hay procedimiento.
- Nutrición con proteínas 1,2–1,5 g/kg/día y colación nocturna; abstinencia de alcohol; evitar AINE, aminoglucósidos y benzodiacepinas.
- Seguimiento: derivar a hepatología para evaluar trasplante hepático.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 59 años con cirrosis hepática alcohólica, en control en policlínico. Se desea estimar su pronóstico mediante la clasificación de Child-Pugh. **¿Cuál de los siguientes parámetros NO forma parte de la clasificación de Child-Pugh?**

A Bilirrubina total

B Creatinina plasmática

C Tiempo de protrombina o INR

D Albúmina plasmática

E Presencia y grado de ascitis

Respuesta B. Child-Pugh incluye bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina o INR, ascitis y encefalopatía. La creatinina no forma parte de Child-Pugh: está en el MELD (bilirrubina, INR, creatinina y sodio en el MELD-Na), que se usa para priorizar el trasplante hepático.

▶ VER CLASE 1.06.1.023 Intolerancia a la lactosa

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.3 · Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Déficit de lactasa (primario del adulto, o secundario a gastroenteritis, celíaca o Crohn): distensión, flatulencia, dolor y diarrea osmótica tras los lácteos, sin esteatorrea.
- Diagnóstico: clínico con prueba de exclusión de lactosa 2 semanas, o test de hidrógeno espirado.
- Tratamiento: reducir la lactosa según tolerancia (yogur y quesos maduros suelen tolerarse), leche sin lactosa o lactasa exógena.
- Asegurar aporte de calcio y vitamina D.
- No confundir con galactosemia del recién nacido (ictericia, daño hepático, cataratas): fórmula de soya; en ella la lactancia y la leche sin lactosa están prohibidas.
- Seguimiento completo en APS; si hay baja de peso o anemia, descartar celíaca o EII.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 24 años con distensión, meteorismo, dolor cólico y deposiciones líquidas que aparecen 1 a 2 horas después de tomar leche o comer helado. No tiene baja de peso, sangre en las deposiciones ni anemia. Los anticuerpos anti-transglutaminasa son negativos. **¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico más probable?**

A Test de D-xilosa
B Biopsia duodenal
C Colonoscopía con biopsias
D Elastasa fecal
E Test de hidrógeno espirado con carga de lactosa

Respuesta E. Síntomas osmóticos y fermentativos ligados a los lácteos, sin signos de alarma, sugieren intolerancia a la lactosa por hipolactasia. Se confirma con el test de hidrógeno espirado tras una carga de lactosa, o con la exclusión y reintroducción de lácteos. Se trata reduciendo la lactosa o con lactasa, sin eliminar todo el calcio.

▶ VER CLASE 1.06.1.024 Masa hepática

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.4 · Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares

QUÉ HAY QUE SABER

- Primer examen: ecografía abdominal; la palabra clave del informe y el contexto orientan.
- Benignas que se observan: quiste simple (anecogénico, pared fina), hemangioma (hiperecogénico homogéneo), hiperplasia nodular focal (cicatriz central).
- Adenoma: hipoecogénico único en mujer con anticonceptivos o anabólicos; suspender estrógenos y resecar si >5 cm o da síntomas.
- Quiste hidatídico (rural, perros; membranas, tabiques, vesículas hijas): albendazol + cirugía, nunca punción libre. Absceso con fiebre: amebiano (metronidazol) o piógeno (antibióticos + drenaje).
- Lesión heterogénea en cirrótico con AFP alta: hepatocarcinoma, confirmar con TAC o RM trifásica (realce arterial y lavado). Lesiones múltiples hipoecogénicas: metástasis, buscar el primario.
- Seguimiento: derivar lesiones sólidas indeterminadas o sospechosas a gastroenterología/cirugía.

PREGUNTAS · 10

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 93

Paciente de 70 años, con cirrosis hepática, sin hábito alcohólico actual, AgHBs negativo y anticuerpos anti-VHC negativos, Child Pugh clase A. Ecografía abdominal: lesión sólida en el lóbulo hepático derecho, de 3,5 cm, de aspecto hipoecogénico. Alfafetoproteína 5,3 ng/mL (VN 0–7). **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Metástasis hepática
B Adenoma hepático
C Carcinoma hepatocelular
D Quiste hepático
E Hemangioma hepático

Respuesta B. Lesión sólida, hipoecogénica, homogénea, con alfafetoproteína normal: adenoma hepático. La cirrosis eleva el riesgo tanto de adenoma como de hepatocarcinoma, pero aquí la AFP no está elevada, lo que aleja el hepatocarcinoma. Las metástasis serían múltiples; el hemangioma sería hiperecogénico; el quiste sería anecogénico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 24

Paciente con daño hepático crónico por consumo de alcohol, en TAC abdominal de control: tumor sólido en el lóbulo hepático derecho, de 3 cm, hipervascular en la fase arterial. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Nódulo de regeneración
B Hepatocarcinoma
C Hemangioma hepático
D Hiperplasia nodular
E Adenoma hepático

Respuesta B. El daño hepático crónico se asocia tanto a adenoma como a hepatocarcinoma, pero la hipervascularización en fase arterial —el realce arterial que después lava— orienta a hepatocarcinoma. Es exactamente el patrón que se busca con el TAC o la RM trifásico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 54

Paciente de 39 años, con obesidad, en quien una ecografía abdominal muestra hígado graso leve, un quiste hepático simple de 1,0 cm y un pólipo vesicular de 0,5 cm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Biopsia por punción del pólipo

B Controlar con una nueva ecografía en 6 meses

C Laparotomía exploradora

D Colecistectomía laparoscópica

E Punción del quiste hepático

Respuesta B. Pólipo vesicular bajo 10 mm, en un hallazgo de rutina: colesterolínico, se sigue con ecografía. El quiste hepático simple menor a 1 cm tampoco requiere intervención. Ni la colecistectomía ni la punción tienen indicación aquí: el corte para operar un pólipo es 1 cm o más.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 34 años, usuaria de anticonceptivos orales hace 8 años, con dolor vago en hipocondrio derecho. Ecografía: lesión hepática sólida, hipoecogénica, homogénea, única, de 6 cm. Sin daño hepático crónico; alfa-fetoproteína normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Observación con ecografía anual

B Suspender anticonceptivos y resecar la lesión

C Punción biopsia percutánea

D Albendazol y cirugía

E Evaluar trasplante hepático según criterios de Milán

Respuesta B. Lesión sólida hipoecogénica, homogénea y única en mujer joven usuaria de ACO, sin cirrosis: adenoma hepático. Por su tamaño (> 5 cm) y el riesgo de hemorragia y malignización, se suspenden los estrógenos y se reseca. El hemangioma sería hiperecogénico; el hepatocarcinoma, en hígado dañado con AFP alta.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En una ecografía solicitada por dispepsia se informa una lesión hepática de 3 cm, hiperecogénica, homogénea y de bordes bien definidos, en un paciente de 40 años sin antecedentes hepáticos ni baja de peso. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?**

A Metástasis hepática; TAC de tórax-abdomen-pelvis

B Hemangioma hepático; observación

C Hepatocarcinoma; derivar para resección

D Absceso hepático; antibióticos y drenaje

E Quiste hidatídico; albendazol

Respuesta B. Lesión hiperecogénica, homogénea y bien delimitada en un hígado sano: hemangioma, la lesión hepática benigna más frecuente. Se observa; si hay dudas, se confirma con RM. La cirugía solo en hemangiomas gigantes y sintomáticos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 89

Paciente de 55 años, con antecedente de esteatohepatitis no alcohólica y obesidad, se realiza ecografía abdominal como parte de chequeo donde se aprecia lesión levemente hipoecogénica, redondeada, sin sombra acústica ni refuerzo posterior. El diagnóstico más probable es:

A Hiperplasia nodular focal

B Hepatocarcinoma

C Adenoma

D Hemangioma

E Hidatidosis hepática

Respuesta B. En un paciente de 55 años con esteatohepatitis no alcohólica, que puede evolucionar a cirrosis, una lesión sólida hipoecogénica sin sombra ni refuerzo posterior debe considerarse hepatocarcinoma hasta demostrar lo contrario y estudiarse con TAC o RM trifásica y alfafetoproteína. El adenoma y la hiperplasia nodular focal son propios de mujeres jóvenes, el hemangioma suele ser hiperecogénico y la hidatidosis es quística.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 44

Nódulo hepático sólido: Estudio con ecografía abdominal > con que continuar el estudio

A TAC Trifasico

B Biopsia

C RNM

D Eco

E Hemograma y VHS

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (TAC Trifasico).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 92

Un paciente de 62 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo dos y de daño he- pático crónico secundario a una esteatohepatitis no alcohólica, ha presentado hospitali- zaciones por cuadros de hemorragia digestiva alta en el último año, actualmente con- trolado. Se realizan exámenes de control en que se demuestra fosfatasas alcalinas de 565 UI/L, GOT: 186 UI/L GPT: 172 UI7L, bilirrubina total 4,2mg/dL, alfafetoproteina: 119 ng/mL. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio de este paciente?

A Endoscopía digestiva alta
B Ecografía abdominal
C TAC abdominal
D Gammaglutamil transferasa
E Colangioresonancia

Respuesta B. La sospecha es un cáncer hepático, dada la alfafetoproteína de 119. Se inicia el es- tudio con una Ecografía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 84

3) Una paciente de 72 años de edad, con antecedente de cirrosis hepática por consumo de alcohol, suspendido hace 5 años acude a control médico. Trae VHBsAg (-) y Anticuerpos anti- VHC (-), Child Pugh clase A, MELDS: 8 puntos, se realiza una ecografía abdominal, que muestra una lesión sólida, en el lóbulo hepático derecho, de 3,5 cm y aspecto hipoecogénico, que en la tomografía se aprecia sólido e hipervascular en la fase arterial. El diagnóstico más probable es:

A Colangiocarcinoma
B Adenoma hepático
C Carcinoma hepatocelular
D Quiste hepático
E Hemangioma hepático

Respuesta C. El antecedente de DHC y el aspecto hipervascular orientan fuertemente a que es un hepatocarcinoma. Los adenomas también son bien delimitados e hipoecogénico, pero suelen verse principalmente en mujeres en edad fértil, que usan ACO o en hombres que usan anabólicos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 164

Un paciente de 69 años, con daño hepático crónico, por consumo de alcohol, score de Child Pugh B, acude a control. Al examen físico tiene ascitis moderada, ictericia de piel y mucosas, sin encefalopatía. Sus pruebas hepáticas muestran bilirrubina: 3,1 mg/dl, SGOT: 50 UI/L, SGPT: 39 UI/L, albúmina: 3,0 g/dl, FA: 110 UI/L. Se solicita una ecografía abdominal que, además de la ascitis, muestra dos lesiones hepáticas hipoecogénicas de 2,2 cm y 1,6 cm, respectivamente. En una imagen anterior, realizada hace 6 meses, se veían las mismas lesiones, pero de menor tamaño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Nódulos de regeneración
B Adenomas hepáticos
C Hemangiomas hepáticos
D Hepatocarcinomas
E Quistes simples hepáticos

Respuesta D. Diagnóstico: Hepatocarcinomas (opción D). Clase sobre el enfoque global de la ictericia.

▶ VER CLASE **1.06.1.025** **Pancreatitis crónica** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 4.2 · Pancreatitis Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Inflamación crónica con fibrosis irreversible del páncreas; causa principal el alcohol (también tabaco, obstrucción ductal, genética, autoinmune).
- Sospechar ante dolor epigástrico recurrente irradiado al dorso, que empeora con la comida, más esteatorrea, baja de peso y diabetes (insuficiencia exocrina y endocrina).
- Malabsorción con test de Sudán positivo y D-xilosa normal (la pared está sana, faltan enzimas); elastasa fecal baja.
- Imagen: calcificaciones pancreáticas en radiografía o TAC (examen de elección), conducto pancreático dilatado e irregular.
- Manejo inicial: suspender alcohol y tabaco, analgesia escalonada, enzimas pancreáticas con las comidas, dieta fraccionada; tratar la diabetes (habitualmente insulina).
- Seguimiento: derivar a gastroenterología (riesgo de seudoquistes, estenosis biliar y cáncer de páncreas).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 140

Hombre de 55 años, alcohólico crónico y fumador, con dolor epigástrico irradiado a la espalda, que aparece con la ingesta de alimentos y se calma al inclinarse hacia adelante. Ha bajado 8 kg de peso. Transaminasas y amilasa levemente elevadas. La radiografía muestra calcificaciones en el epigastrio. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Úlcera gástrica perforada
B Obstrucción intestinal
C Pancreatitis crónica
D Colecistitis aguda
E Hepatitis alcohólica

Respuesta C. Dolor epigástrico posprandial irradiado al dorso, alivio en flexión, baja de peso y calcificaciones pancreáticas en un alcohólico son típicos de pancreatitis crónica. La amilasa puede ser normal o levemente elevada por pérdida de parénquima. Se confirma con TAC. La úlcera perforada da abdomen agudo con neumoperitoneo, no calcificaciones.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 138

Un paciente de 60 años, gran fumador y con antecedentes de consumo excesivo de alcohol, hasta hace 6 meses en que suspendió el cigarrillo y la ingesta de alcohol, consulta por episodios de dolor abdominal epigástrico intenso, asociado a vómitos alimentarios. Refiere también episodios de diarrea abundante, que han ido en aumento. Se solicitan exámenes, entre los que muestra hemograma con hematocrito: 39%, blancos: 9.000 por mm3, plaquetas: 250.000 por mm3; glicemia de ayuno: 122 mg/dL, lipasa plasmática: 210 UI/L, amilasa plasmática: 90 UI/L, fosfatasa alcalina: 210 UI/L, GOT: 32 UI/L, GPT: 40 U/L y GGT: 70 UI/L. Se realiza ecografía abdominal, que se describe como “ventana ecográfica insuficiente por meteorismo”. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Pancreatitis aguda
B Colecistitis aguda
C Cáncer de páncreas
D Coledocolitiasis
E Pancreatitis crónica

Respuesta E. Pancreatitis Crónica: El caso describe una pancreatitis crónica con complicaciones típicas como diabetes (tien glicemia de ayuno alterada y no aún diabetes) y síndrome de mala absorción. Se caracteriza por dolor abdominal, generalmente después de ingerir alimentos o alcohol. La causa más frecuente es el alcoholismo.

▶ VER CLASE 1.06.1.026 Parasitosis intestinales

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.1 · Diarrea Aguda y Crónica en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Giardiasis: diarrea crónica, flatulencia, dolor cólico y malabsorción en preescolar rural o varios familiares; descartarla antes de diagnosticar celíaca. Tratamiento: tinidazol o metronidazol.
- Oxiuriasis (Enterobius): prurito anal nocturno en niños; test de Graham. Mebendazol 100 mg dosis única repetida a las 2 semanas, tratando a todo el grupo familiar.
- Ascariasis: dolor abdominal, puede obstruir intestino o vía biliar; Taenia (carne cruda) y teniasis: eliminación de proglótidas; praziquantel o albendazol. Amebiasis: disentería o absceso hepático, metronidazol.
- Diagnóstico: parasitológico seriado de deposiciones (3 muestras); test de Graham para oxiuros.
- Prevención: lavado de manos, agua potable, lavado de verduras, cocción adecuada de carnes, eliminación sanitaria de excretas.
- Seguimiento completo en APS; control parasitológico post tratamiento en casos persistentes.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niña de 5 años que asiste a jardín infantil presenta prurito anal de predominio nocturno hace 3 semanas, con sueño intranquilo. Al examen se observan lesiones por grataje perianal. El test de Graham es positivo. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Metronidazol a la paciente por 7 días
B Crema de corticoide perianal
C Praziquantel en dosis única a la paciente
D Mebendazol a la paciente y a todo el grupo familiar, repitiendo la dosis a las 2 semanas
E Nitazoxanida solo a la paciente

Respuesta D. El test de Graham positivo confirma oxiuriasis por Enterobius vermicularis. Se trata a todo el grupo familiar con mebendazol o albendazol, repitiendo a las 2 semanas por el ciclo de autoinfección, junto con medidas de higiene como uñas cortas y lavado de ropa de cama. Metronidazol es para protozoos y praziquantel para teniasis.

▶ VER CLASE 1.06.1.027 Reflujo gastroesofágico

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.1 · Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett

QUÉ HAY QUE SABER

- Pirosis retroesternal y regurgitación ácida, peor al acostarse y tras comidas abundantes; causa: falla de la barrera (relajaciones transitorias del EEI, hernia hiatal), no exceso de ácido.
- Presentación atípica: tos crónica, asma difícil, disfonía, erosiones dentales, dolor torácico no cardíaco (descartar primero el corazón).
- Típico, menor de 50 y sin alarma: diagnóstico clínico + prueba con IBP 4–8 semanas. Alarma (disfagia, baja de peso, anemia, hemorragia, inicio >50, pirosis >5 años): endoscopía con biopsias. Duda o atípico: pH-metría de 24 h.
- Tratamiento: medidas generales (elevar cabecera, bajar de peso, fraccionar, evitar comidas tardías, tabaco y alcohol) + omeprazol en ayunas 30–60 min antes del desayuno. No se erradica H. pylori por reflujo.
- Cirugía (funduplicatura de Nissen): joven dependiente de IBP, reflujo grave o hernia hiatal voluminosa sintomática.
- Seguimiento completo: Barrett (metaplasia intestinal en biopsia) sin displasia = IBP + vigilancia endoscópica; con displasia, derivar para ablación o resección.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 65

Paciente con pirosis y regurgitación. La endoscopía digestiva alta muestra la línea Z a 20 cm y la impresión diafragmática a 30 cm de la arcada dentaria. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Esófago de Barrett
B Hernia hiatal por deslizamiento (tipo I)
C Hernia hiatal paraesofágica (tipo II)
D Acalasia
E Esofagitis erosiva grado B

Respuesta B. La línea Z debería coincidir con la impresión diafragmática. Aquí está 10 cm por encima: la unión gastroesofágica subió al tórax, lo que define la hernia hiatal por deslizamiento. El Barrett es un diagnóstico de biopsia, no de centímetros.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 120

Un paciente de 26 años consulta por pirosis y regurgitación de varios meses de evolución. Su examen físico no aporta mayor información. Se realiza una endoscopía digestiva alta que muestra mucosa de aspecto normal, línea Z a 28 cm de la arcada dentaria e impresión hiatal diafragmática a 37 cm de la arcada dentaria. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Acalasia esofágica
B Hernia hiatal directa
C Hernia paraesofágica
D Esófago de Barrett
E Divertículo esofágico

Respuesta B. La línea Z (unión gastroesofágica) está más arriba que la impresión diafragmática: es una hernia por deslizamiento, tipo I o "directa". Se maneja con observación, tratando el reflujo solo si aparece. La paraesofágica, en cambio, sí se opera por el riesgo de complicaciones.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 65

Un paciente de 36 años consulta por disfonía de varios meses de evolución, de predominio matinal, que mejora durante el día y que se intercala con periodos de tiempo en los cuales no tiene alteraciones de la voz. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar esomeprazol
B Iniciar prednisona oral
C Solicitar endoscopía digestiva alta
D Solicitar radiografías contrastadas de esófago-estómago-duodeno
E Solicitar TAC de cuello

Respuesta A. Parece una disfonía por reflujo, de predominio matinal. Se puede hacer una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones, aunque lo mejor suele ser una pHmetría para confirmar.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 32 años, oficinista, consulta por 4 meses de ardor retroesternal ascendente que empeora tras el almuerzo y al acostarse, con regurgitación ácida. Niega disfagia, odinofagia, vómitos, baja de peso o anemia. Examen físico normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar omeprazol 20 mg al día en ayunas por 4 a 8 semanas
B Solicitar endoscopía digestiva alta con biopsias
C Solicitar pH-impedanciometría esofágica de 24 horas
D Indicar ranitidina 150 mg cada 12 horas y medidas posturales
E Solicitar radiografía de esófago, estómago y duodeno con bario

Respuesta A. Joven, clínica típica y sin alarma: el diagnóstico es clínico y se indica prueba con IBP por 4–8 semanas. La endoscopía se reserva para la alarma o el inicio después de los 50 años; la pH-metría, para la duda o la clínica atípica; los antagonistas H2 están desplazados.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 84

Un hombre de 30 años presenta pirosis frecuente, por lo que se solicita una endoscopía digestiva alta, que muestra una esofagitis por reflujo, grado A. Se inician inhibidores de la bomba de protones por 6 meses. Al control refiere buena respuesta, sin embargo, los síntomas recurren al suspender el tratamiento. La conducta más adecuada es:

A Repetir la endoscopía digestiva alta
B Solicitar pH-metría esofágica
C Indicar inhibidores de la bomba de protones
D Solicitar manometría esofágica
E Cambiar a antihistamínicos H2

Respuesta C. Tiene reflujo clínico y por endoscopía. El tratamiento es IBP (ej. omeprazol) a permanencia. Que los síntomas hayan recurrido, solo hace que con mayor razón sea reflujo y se deban reiniciar los IBP.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 38

Un paciente de 27 años, con historia de pirosis y regurgitación de algunos meses de evolución, siendo diagnosticado de reflujo gastroesofágico. Se indican cambios en los hábitos alimentarios y omeprazol a razón de 20 mg al día y se controla un mes después con endoscopía digestiva alta que demuestra esofagitis distal severa y test de ureasa (+). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Agregar prokinéticos
B Agregar antiácidos
C Duplicar la dosis de omeprazol
D Erradicar Helicobacter Pilory
E Tratamiento quirúrgico

Respuesta E. Es un RGE grave, en un paciente joven, con respuesta incompleta al omeprazol: Es la principal indicación de cirugía, además del esófago de Barret.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 145

Una paciente de 34 años consulta por disfonía intermitente, principalmente en la mañana, asociada a carraspera. Su examen físico es normal. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?

A Azitromicina oral 500 mg/día por 5 días
B Prednisona oral 20 mg/día
C Lanzoprazol oral 20 mg/día por 30 días
D Amoxicilina oral 500 mg/8 horas por 7 días
E Ibuprofeno 400 mg/8 horas por 7 días

Respuesta C. Es una pregunta rara, pero se trata de un caso de RGE con síntomas atípicos: disfonía matinal. Otros son caries y asma de difícil manejo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 41

Una paciente de 59 años inicia un cuadro de 3 semanas de evolución de pirosis y dolor epigástrico, con episodios diurnos y nocturnos. Su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar endoscopía digestiva alta
B Solicitar ecografía abdominal
C Solicitar TAC de abdomen
D Iniciar omeprazol oral
E Medir pH esofágico de 24 horas

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Medir pH esofágico de 24 horas (opción E).

▶ VER CLASE 1.06.1.028 **Síndrome de malabsorción** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.3 · Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante diarrea crónica con baja de peso pese a ingesta conservada, esteatorrea y signos carenciales (anemia ferropénica o megaloblástica, hipocalcemia, osteomalacia, glositis, coagulopatía).
- Test de Sudán confirma esteatorrea; D-xilosa localiza: alterada = pared (celíaca, Crohn, intestino corto); normal = enzimas (pancreatitis crónica, fibrosis quística).
- Estudio dirigido: anti-transglutaminasa IgA con IgA total, parasitológico (Giardia), elastasa fecal, imagen pancreática, endoscopía con biopsia duodenal.
- Manejo inicial: corregir déficits (hierro, folato, B12, calcio, vitamina D, K) y soporte nutricional; tratar la causa identificada.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología para completar el estudio etiológico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 17

Mujer de 40 años consulta por deposiciones frecuentes y diarrea de 3 meses de evolución. Presenta urgencia defecatoria, especialmente tras ingerir alimentos ricos en grasa, y nota gotas de grasa flotando en el inodoro luego de defecar. Además refiere baja de peso no cuantificada. Su examen físico muestra signos vitales normales y un abdomen blando, depresible, sin signos peritoneales ni masas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Enfermedad celíaca

B Insuficiencia pancreática exocrina

C Sobrecrecimiento bacteriano

D Colitis ulcerosa

E Giardiasis

Respuesta B. Es un síndrome de malabsorción con esteatorrea franca, que empeora con las grasas: lo clásico de la insuficiencia pancreática exocrina, es decir, una maldigestión. La celíaca también da malabsorción, pero suele predominar la anemia ferropénica sin una esteatorrea tan marcada; la colitis ulcerosa da diarrea con sangre.

▶ VER CLASE 1.06.1.029 Tumores de colon

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.5 · Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje

QUÉ HAY QUE SABER

- Pólipos: hiperplásico no premaligno; adenomatoso (tubular, tubulovelloso, velloso: el de mayor riesgo) progresa a cáncer en ~10 años; polipectomía y colonoscopía en 1–3 años.
- Clínica del cáncer según ubicación: colon derecho anemia ferropénica y masa; izquierdo constipación progresiva, cambio del hábito, rectorragia y obstrucción (1.ª causa de obstrucción de colon en el adulto); recto hematoquecia, tenesmo.
- Diagnóstico: colonoscopía total con biopsia (sintomático o con alarma: colonoscopía directa, no sangre oculta). Etapificación con TAC de tórax, abdomen y pelvis; recto: RM de pelvis.
- CEA solo para seguimiento postoperatorio, no diagnostica.
- Síndromes hereditarios: poliposis adenomatosa familiar (cientos de pólipos, 100 % malignizan: colectomía profiláctica); Lynch (pocos pólipos: vigilancia colonoscópica intensiva).
- Seguimiento: derivar a cirugía (hemicolectomía; quimioterapia; radioterapia en recto). GES de cáncer colorrectal.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 50

Un paciente de 70 años consulta por un cuadro de varios meses de evolución de constipación, alternado con diarrea. Su examen físico no aporta mayor información. En sus exámenes destaca hematocrito de 36 % y hemoglobina de 12 g/dL. **¿Qué examen debe solicitarse a continuación?**

A Test de sangre oculta en deposiciones

B Ecografía abdominal

C TAC de abdomen y pelvis

D Colonoscopía

E Rectosigmoidoscopía

Respuesta D. Constipación que alterna con diarrea (cambio del hábito intestinal) en un adulto mayor de 50 años es una señal de alarma que obliga a descartar cáncer de colon con colonoscopía, aunque los exámenes básicos aún estén casi normales.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 175

Paciente mayor de 50 años con pólipo resecado en la colonoscopía: adenoma velloso con displasia de bajo grado. **¿Cuál es la conducta?**

A Colonoscopía de control en 1 año

B Colonoscopía de control en 3 años

C Colonoscopía de control en 5 años

D Hemicolectomía profiláctica

E Colonoscopía de control en 10 años

Respuesta B. El adenoma resecado, cualquiera sea su histología o su grado de displasia, se controla con una nueva colonoscopía en 1 a 3 años. No corresponde cirugía por un solo pólipo resecado por completo en la endoscopía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 28

Un paciente de 64 años presenta dolor abdominal desde hace un mes, asociado a cambio en el hábito intestinal. Su examen físico no aporta mayor información. Se había realizado un hemograma que muestra una anemia microcítica. **¿Qué examen se debe solicitar?**

A Colonoscopía
B Radiografía simple de abdomen y pelvis
C Ecografía abdominal
D Tomografía axial computarizada de abdomen y pelvis
E Test de sangre oculta en deposiciones

Respuesta A. Hombre de 64 años con cambio del hábito intestinal y anemia microcítica: la sospecha es un cáncer de colon, y el examen es la colonoscopía. La sangre oculta no aporta: la anemia ferropénica ya es la evidencia de la pérdida.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 31

Un paciente de 45 años nota cambio en el hábito intestinal desde hace dos meses, requiriendo mayor esfuerzo defecatorio. Además, ha notado presencia ocasional de mucosidad y sangre en las deposiciones. Su examen físico muestra signos vitales normales y la exploración abdominal no presenta alteraciones ¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada para iniciar su estudio?

A Ecografía abdominal
B TAC abdominal
C Colonoscopía
D Rectosigmoidoscopía
E Test de sangre oculta en deposiciones

Respuesta C. Cáncer colorrectal: La sospecha diagnóstica es un cáncer colorrectal. Si bien se puede iniciar el estudio con una colonoscopía o una rectosigmoidoscopía, se recomienda la exploración de todo el colon, por lo que la colonoscopía es la respuesta correcta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 1

Una paciente de 92 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer por lo que está institucionalizada, presenta un cuadro de astenia, debilidad, baja de peso de 6 kilos en los últimos dos meses, asociado a hematoquesia intermitente en algunas oportunida- des, que los familiares atribuyen a hemorroides externos. Al examen físico presenta un abdomen blando, depresible, con ruidos hidroaéreos presentes. Su piel se aprecia algo pálida y sus signos vitales son normales. ¿Con que examen debe iniciarse el estudio en esta paciente?

A Ecografía abdominal
B TAC de abdomen y pelvis
C Resonancia magnética de abdomen y pelvis
D Colonoscopía corta
E Colonoscopía completa

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Colonoscopía completa). Se sospecha un cáncer de colon, que se estudia con colonoscopía completa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 14

Paciente 50 años aprox con cambio de hábito intestinal y baja de peso 8 kilos: a. colonoscopía

A Ninguna de las anteriores es correcta
B Todas las anteriores son correctas
C No se dispone de información suficiente
D Otra alternativa no descrita
E Otra alternativa no descrita

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Ninguna de las anteriores es correcta).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 68

Una paciente de 54 años presenta cambio en el hábito intestinal, asociada a distensión abdominal. Se realiza una ecografía abdominal, que muestra un pólipo de 5 mm en la vesícula biliar, de aspecto homogéneo y delimitado. La conducta más adecuada es:

A Indicar dieta baja en grasas
B Realizar colecistectomía
C Solicitar PCR ultrasensible
D Realizar TAC de abdomen
E Realizar colonoscopía

Respuesta E. El pólipo vesicular no tiene importancia, por tener aspecto benigno. En cambio, el cambio en el hábito intestinal es algo que sugiere cáncer de colon y obliga a hacer una colonoscopía completa.

▶ VER CLASE **1.06.1.030** **Úlcera péptica** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.5 · Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)
Gastroenterología 1.2 · Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori
Gastroenterología 1.4 · Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico

QUÉ HAY QUE SABER

- Causas: H. pylori (90 % de las duodenales, 70 % de las gástricas) y AINE; tabaco y corticoides potencian. Epigastralgia urente, peor en ayunas (duodenal).
- Endoscopía si ≥40 años o alarma. Duodenal: no se maligniza, erradicar siempre; gástrica: biopsia del borde siempre y endoscopía de control para documentar cicatrización.
- H. pylori por test de ureasa en biopsia, aire espirado o antígeno fecal (falsos negativos con IBP previo o sangrado reciente).
- Tratamiento: IBP 4–8 semanas + erradicación (IBP + amoxicilina 1 g + claritromicina 500 mg c/12 h por 14 días; segunda línea cuádruple con bismuto); suspender AINE.
- Control de erradicación con aire espirado o antígeno fecal a las 4 semanas post antibióticos y 2 semanas sin IBP.
- Complicaciones: HDA (IBP EV + endoscopía urgente) y perforación (Rx de tórax de pie, cirugía; endoscopía contraindicada). Seguimiento completo en APS.

PREGUNTAS · 10

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 129

Hombre de 42 años con 5 días de dolor epigástrico intenso y fluctuante, con náuseas, que empeora con el ayuno y tras usar antiinflamatorios. FC 85 lpm, PA 130/82 mmHg. Dolor a la palpación epigástrica, sin signos peritoneales, masas ni visceromegalia. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Gastritis erosiva
B Úlcera péptica
C Reflujo gastroesofágico
D Pancreatitis aguda leve
E Colecistitis aguda

Respuesta B. Epigastralgia que empeora en ayunas y se gatilla con AINE: síndrome ulceroso. Sin dolor en faja ni signos peritoneales no es pancreatitis; sin dolor en hipocondrio derecho no es colecistitis; el reflujo da pirosis y regurgitación.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 12

Paciente de 27 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 3 meses de dolor epigástrico tipo urente que aumenta durante los periodos de ayuno y estrés, asociado ocasionalmente a pirosis. Se realiza endoscopía digestiva alta que objetiva úlcera duodenal activa y se realiza test de ureasa que resulta negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este caso?**

A Iniciar omeprazol, amoxicilina y claritromicina
B Indicar omeprazol y controlar con nueva endoscopía en 6 semanas
C Solicitar nueva endoscopía digestiva alta con test de ureasa
D Iniciar omeprazol, bismuto y metronidazol
E Iniciar medidas antirreflujo y omeprazol a permanencia

Respuesta A. Úlcera duodenal activa en un paciente que no usa AINEs: se asume Helicobacter pylori, que explica cerca del 90% de estos casos, aunque el test de ureasa sea negativo, porque este tiene falsos negativos. Se erradica con terapia triple: omeprazol, amoxicilina y claritromicina.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 27 años, sin antecedentes ni uso de antiinflamatorios, con 3 meses de dolor epigástrico urente que aumenta con el ayuno y calma al comer. La endoscopía muestra una úlcera duodenal activa de 1 cm; el test de ureasa es negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar esquema erradicador de Helicobacter pylori por 14 días
B Indicar omeprazol 20 mg al día por 8 semanas, sin antibióticos
C Solicitar tomografía computarizada de abdomen y pelvis
D Repetir la endoscopía en 4 semanas para nuevo test de ureasa
E Solicitar gastrina sérica para descartar gastrinoma

Respuesta A. Úlcera duodenal sin AINE: se erradica siempre, aunque el test sea negativo (los falsos negativos son frecuentes). Solo con IBP la úlcera cicatriza pero recidiva en cerca del 90 %; repetir estudios retrasa el tratamiento.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años con epigastralgia de meses consulta por dolor epigástrico súbito, "como una puñalada", que en 1 hora se extendió a todo el abdomen. Está pálido y taquicárdico, con abdomen rígido, doloroso en forma difusa y sin ruidos hidroaéreos. La radiografía de tórax de pie muestra aire bajo el hemidiafragma derecho.
¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Endoscopía digestiva alta urgente
B Suero, IBP endovenoso y antibióticos, y observar
C Cirugía de urgencia
D TAC de abdomen con contraste
E Sonda nasogástrica y régimen cero por 48 horas

Respuesta C. Síndrome ulceroso + dolor en puñalada que se generaliza + abdomen en tabla + neumoperitoneo = úlcera perforada. El tratamiento es la cirugía de urgencia (sutura + parche de epiplón). Suero, IBP y antibióticos acompañan pero no reemplazan la cirugía; la endoscopía está contraindicada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 163

Una paciente de 40 años, con antecedente de artritis reumatoide, tratada con naproxeno oral, presenta un episodio de hemorragia digestiva alta, con melena. Se realiza una endoscopía digestiva alta, que muestra una úlcera duodenal activa; no se realizó el test de ureasa. La conducta más adecuada es:

A Cambiar el naproxeno por otro AINE
B Solicitar serología para Helicobacter pylori
C Solicitar nueva endoscopía con test de ureasa
D Realizar erradicación de Helicobacter pylori
E Iniciar inhibidores de la bomba de protones

Respuesta D. Las úlceras gástricas se erradican solo si tienen HP positivo (a menos que no haya consumo de AINEs y exista algo que genere falsos positivos, como el uso de antibióticos o de omeprazol) y se controlan con una EDA, de modo de descartar que haya un cáncer debajo. Las úlceras duodenales (este caso) se erradican siempre, ya sea con HP positivo o negativo y se controlan con pruebas no invasivas, como la detección de antígenos en heces. Por ello, la respuesta es erradicar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 124

Un paciente es diagnosticado de úlcera gástrica, con test de ureasa positiva, por lo que se inicia tratamiento con amoxicilina 1g cada 12 horas, claritromicina 500mg cada 12 horas y omeprazol 20mg cada 12 horas, por 10 días. Luego queda con omeprazol por 4 semanas más. Se controla posteriormente con antígeno de H. pylori en heces, que resulta positivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Repetir el tratamiento, pero por 14 días
B Realizar endoscopía digestiva alta y biopsia
C Indicar tratamiento erradicador de segunda línea
D Realizar test de ureasa
E Observar evolución

Respuesta C. Si bien la recomendación del Minsal es 14 días de tratamiento, hay suficiente evidencia que dicen que los tratamientos de 7 a 10 días son buenos. Si falla la erradicación, se debe dejar tratamiento erradicador de segunda línea. Otro problema con esta pregunta es que solo la úlcera duodenal se controla con antígeno en heces, mientras que la ulcera gástrica debería controlarse con EDA y biosia, para observar la curación de la úlcera y biopsiar el lecho (descartar cáncer). La pregunta es muy...

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 71

Paciente con antecedente de úlcera gastroduodenal y anemia ferropénica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Iniciar hierro oral y controlar hemograma
B Solicitar estudio de deposiciones para sangre oculta
C Biopsias gástricas y test de ureasa
D Erradicar H. pylori empíricamente
E Solicitar endoscopía digestiva alta

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Solicitar endoscopía digestiva alta (opción E). Solicitar endoscopía digestiva alta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 15

Un paciente masculino, de 34 años, consulta por dolor abdominal epigástrico, de dos meses de evolución, mayor postprandial y que cede con antiácidos. En el último tiempo se agregan vómitos postprandiales. Hace pocos días presentó un episodio de dolor nocturno, de moderada intensidad. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio en este paciente?

A Ecografía abdominal
B pH esofágico de 24 horas
C Radiografías baritadas de esófago, estómago y duodeno
D Endoscopía digestiva alta
E TAC de abdomen y pelvis

Respuesta D. Se sospecha una úlcera gastroduodenal (aunque el dolor suele ser más intenso en ayunas). Se estudia con EDA.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 70

Un paciente de 36 años se hace una endoscopía digestiva alta, que muestra test de ureasa positiva para Helicobacter pylori. Como antecedente, tuvo una hemorragia digestiva alta hace 2 años, por una úlcera duodenal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Repetir la endoscopía digestiva alta

B Erradicar Helicobacter pylori

C Solicitar el test del aliento con úrea-C14

D Iniciar antihistamínicos H2

E Indicar omeprazol por 6 meses

Respuesta B. Se erradican los pacientes con antecedente de úlcera y los con factores de riesgo para úlcera (uso de AINEs, dispepsia) y cáncer (displasia, metaplasia, antecedentes familiares marcados).

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 70

Paciente con artritis reumatoide en tratamiento con AINEs, presenta melena. ¿Diagnóstico más probable?

A Cáncer gástrico

B Úlcera gastroduodenal

C Angiodisplasia gástrica

D Esofagitis erosiva

E Síndrome de Mallory-Weiss

Respuesta B. Diagnóstico: Úlcera gastroduodenal (opción B). Úlcera gastroduodenal.

Situaciones clínicas de urgencia

12 códigos

▶ VER CLASE **1.06.2.001** **Abdomen agudo** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Gastroenterología 5.1 · Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis
Gastroenterología 5.2 · Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular

QUÉ HAY QUE SABER

- Dolor abdominal agudo que puede requerir resolución urgente; el diagnóstico es clínico. Signos peritoneales: resistencia, Blumberg, abdomen en tabla con silencio abdominal.
- Mujer en edad fértil con dolor abdominal bajo: test de embarazo y evaluación ginecológica primero (embarazo ectópico).
- Apendicitis: dolor periumbilical que migra a fosa ilíaca derecha, anorexia, McBurney; diagnóstico clínico (eco en niños y mujeres fértiles, TAC si hay duda). Diverticulitis: fosa ilíaca izquierda, TAC.
- Perforación de víscera hueca: dolor en puñalada, abdomen en tabla; Rx de tórax de pie con neumoperitoneo. Isquemia mesentérica: FA + dolor desproporcionado con abdomen blando, angio-TAC, heparina.
- Manejo inicial: régimen cero, vía venosa e hidratación, analgesia (no retrasa el diagnóstico), exámenes (hemograma, PCR, lipasa, orina, ECG, β-hCG), antibióticos si hay peritonitis.
- Derivar a cirugía; no todos son quirúrgicos (pancreatitis, CAD, IAM inferior, PBE).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 72 años, fumador e hipertenso, consulta por dolor abdominal y lumbar súbito e intenso de 1 hora de evolución. Está pálido y sudoroso, con PA 80/50 mmHg y FC 125 por minuto. Se palpa una masa pulsátil periumbilical. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Reanimación con hipotensión permisiva y traslado inmediato a pabellón

B TAC de abdomen con contraste antes de decidir

C Pielografía por sospecha de cólico renal

D Analgesia y observación

E Ecografía renal y urocultivo

Respuesta A. Dolor abdominal o lumbar súbito, shock y masa pulsátil es un aneurisma aórtico abdominal roto hasta demostrar lo contrario. En el paciente inestable no se espera la TAC: se reanima con hipotensión permisiva y se lleva de inmediato a pabellón. Confundirlo con un cólico renal es el error clásico.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 68 años, con antecedente de histerectomía, consulta por 24 horas de dolor abdominal cólico, vómitos y ausencia de eliminación de gases. Abdomen distendido y timpánico, con ruidos de lucha, sin signos peritoneales. Afebril, FC 92 por minuto, leucocitos y lactato normales. Radiografía: asas de intestino delgado dilatadas con niveles hidroaéreos. **¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A Laparotomía de urgencia inmediata

B Régimen cero, sonda nasogástrica, hidratación endovenosa y reevaluación seriada

C Enema evacuante y proquinéticos

D Colonoscopía descompresiva

E Alta con analgesia y control en 48 horas

Respuesta B. Es una obstrucción de intestino delgado por bridas sin signos de estrangulación. El manejo inicial es régimen cero, sonda nasogástrica, hidratación y corrección electrolítica, con reevaluación seriada. Se opera si aparecen fiebre, peritonismo, leucocitosis o lactato elevado, o si no resuelve en 48 a 72 horas. Los proquinéticos están contraindicados.

▶ VER CLASE 1.06.2.002 Afagia aguda

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 5.4 · Cuerpo Extraño Digestivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Imposibilidad de tragar, incluso la saliva (sialorrea), habitualmente por cuerpo extraño o bolo alimentario impactado en el esófago.
- Radiografía de cuello, tórax y abdomen para localizar el objeto (plástico y espinas pueden no verse). Dolor torácico, fiebre o enfisema: sospechar perforación.
- Todo cuerpo extraño en el esófago se retira por endoscopía; urgente si hay obstrucción completa, pila de botón (necrosis en horas, extracción inmediata), objeto afilado o >24 h.
- Bolo alimentario: si tolera líquidos y no hay dolor puede observarse hasta 24 h; si no traga o duele, endoscopía para desimpactar y luego estudiar la causa (esofagitis eosinofílica, estenosis, anillo, cáncer).
- No inducir el vómito ni usar maniobra de Heimlich (solo para obstrucción de vía aérea).
- Seguimiento: derivar a endoscopía de urgencia.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 50

Disfagia a nivel de la apófisis xifoides luego de comer pollo, que no permitía el paso ni siquiera del agua. **¿Cuál es la conducta?**

A Endoscopía digestiva alta

B Radiografía

C Nasolaringoscopia

D Manometría esofágica

E Derrame pleural

Respuesta A. Un trozo de comida que se impacta y bloquea por completo el esófago, incluso para el agua, es una urgencia: la conducta es la endoscopía digestiva alta, que retira el bolo y de paso muestra si hay una causa de base, como un anillo de Schatzki o una estenosis péptica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 50

Paciente con disfagia a nivel de la apófisis xifoides luego de comer pollo, que no permite el paso ni siquiera de agua. **¿Cuál es la conducta?**

A Endoscopía digestiva alta

B Radiografía

C Nasolaringoscopia

D Manometría esofágica

E Derrame pleural

Respuesta A. Comida impactada en el esófago (probablemente un hueso de pollo) que no deja pasar ni siquiera agua: es una obstrucción completa. La conducta es la endoscopía digestiva alta, sin demora, para desimpactar y por el riesgo de perforación. No se observa, porque no tolera ni líquidos.

▶ VER CLASE 1.06.2.003 Colangitis

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 4.1 · Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Infección de la vía biliar obstruida (coledocolitiasis, estenosis, tumor). Tríada de Charcot: dolor + ictericia + fiebre; péntada de Reynolds: + hipotensión + compromiso de conciencia.
- Laboratorio: leucocitosis, PCR alta, patrón colestásico (bilirrubina directa, FA y GGT); hemocultivos.
- Ecografía: vía biliar dilatada (colédoco >6–7 mm), cálculos.
- Manejo inicial: reposición de volumen, antibióticos de amplio espectro (ceftriaxona + metronidazol) y analgesia.
- Lo esencial es drenar: CPRE urgente; colecistectomía electiva después, cuando el paciente esté estable.

- Seguimiento: derivar de urgencia a centro con CPRE/cirugía.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 145

Mujer de 70 años con dolor abdominal intenso de 24 horas, fiebre hasta 38,5 grados, marcado malestar general y vómitos alimentarios en múltiples ocasiones. Al examen: presión arterial 90/60, frecuencia cardíaca 105 por minuto, ictericia de piel y mucosas, abdomen doloroso de forma difusa, con resistencia muscular, mayor en el hemiabdomen superior. Bilirrubina total 6,8 mg/dL, directa 6,1 mg/dL, fosfatasas alcalinas y GGT elevadas, transaminasas también altas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Colecistitis enfisematosa
B Plastrón vesicular
C Hepatitis aguda
D Colangitis aguda
E Coledocolitiasis

Respuesta D. Dolor, ictericia y fiebre, con compromiso hemodinámico: es la tríada de Charcot que define la colangitis aguda, una urgencia que requiere drenaje de la vía biliar y antibióticos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 97

Paciente de 52 años, con 12 horas de dolor epigástrico intenso irradiado a los flancos, vómitos y orinas oscuras, con fiebre hasta 39 °C. Al examen: ictericia de escleras, piel y mucosas, PA 90/60 mmHg, FC 110/min. Ecografía: colédoco de 11 mm de dilatación y litiasis múltiple en la vesícula. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar colecistectomía laparoscópica
B Realizar colecistectomía abierta más coledocostomía
C Solicitar colangiorresonancia
D Solicitar TAC de abdomen y pelvis
E Realizar drenaje endoscópico de la vía biliar

Respuesta E. Dolor, ictericia y fiebre con compromiso hemodinámico: colangitis aguda grave, con un colédoco ya dilatado en la ecografía. La conducta prioritaria es el drenaje endoscópico de la vía biliar por CPRE, junto con volumen y antibióticos. La colecistectomía se hace después, cuando el paciente esté estable.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 101

Una paciente de 70 años consulta por un cuadro de dolor abdominal y sensación febril, de 6 horas de evolución, a lo que se ha agregado ictericia. Al examen físico pre- senta FC: 87x', PA. 90/60 mmHg, temperatura: 38,5 grados Celsius. Al examen abdominal tiene intenso dolor a la palpación epigástrica, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diag- nóstico más probable?

A Coledocolitiasis
B Colangitis aguda
C Pancreatitis aguda
D Colecistitis aguda
E Hepatitis aguda

Respuesta B. Tiene la triada de Charcot: fiebre, ictericia y dolor, más la hiptensión arterial. Es una colangitis clínica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 96

Una paciente de 50 años consulta por dolor abdominal de 12 horas de evolución, intenso y asociado a vómitos. Además ha presentado fiebre hasta 38,8 grados y aumento del dolor abdominal, en especial en el hemiabdomen superior. Al examen físico tiene ictericia de piel y mucosas, PA: 90/60 mmHg y FC: 116x'. Se realiza una ecografía abdominal que muestra colédoco de 11 mm de dilatación y litiasis en la vesícula biliar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar colecistectomía laparoscópica
B Realizar drenaje endoscópico de la vía biliar
C Solicitar colangioresonancia magnética nuclear
D Solicitar TAC de abdomen y pelvis
E Realizar colecistectomía más coledocostomía

Respuesta B. Tiene criterios de colangitis aguda (dolor, fiebre, ictericia y compromiso hemodinámico), por lo que se debe proceder al drenaje por CPRE.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 23

Una paciente de 50 años, con antecedente de colecistectomía hace varios años, presenta desde hace dos días cuadro de dolor epigástrico, ictericia fluctuante, orinas oscuras y fiebre. Al examen físico destaca frecuencia cardiaca de 100 por minuto, presión arterial de 80/50 mm de Hg, dolor a la palpación epigástrica, blumberg (+), ruidos hidroaéreos disminuidos. Se solicita ecografía abdominal que muestra vía biliar de 10mm. La conducta más adecuada en esta paciente es:

A Realizar colangioresonancia
B Realizar tomografía axial computada de abdomen
C Realizar laparotomía abierta
D Indicar antibióticos de amplio espectro y reevaluar en 48 horas
E Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Respuesta E. Tiene un diagnóstico de colangitis aguda clínica. Se debe hacer drenaje endoscópico de la vía biliar, lo que no aparece en las alternativas. De las opciones, la más aceptable es la CPRE (aunque en realidad lo que se hará es una papilotomía y drenaje). La presencia de Blumberg confunde, ya que podría indicarnos una Cirugía, pero el manejo de elección sigue siendo en drenaje endoscópico. De todos modos es probable que la pregunta original haya estado redactada de otra forma.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 152

Paciente de 60 años con fiebre, ictericia y dolor en hipocondrio derecho (tríada de Charcot). Ecografía: vía biliar dilatada, cálculo en colédoco. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?

A Colangitis aguda: ATB EV + CPRE urgente para drenaje biliar
B Hepatitis aguda: manejo conservador
C Colecistitis aguda: colecistectomía laparoscópica
D Absceso hepático: drenaje percutáneo
E Pancreatitis aguda: reposo y fluidos

Respuesta A. Tríada de Charcot (fiebre + ictericia + dolor en HD) + coledocolitiasis = colangitis aguda. Emergencia: ATB de amplio espectro + drenaje biliar endoscópico urgente (CPRE) para descompresión.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 68

Paciente con dolor en HCD, fiebre, ictericia y coluria, con patrón colestásico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Solicitar ecografía abdominal
B CPRE de urgencia
C Colecistectomía laparoscópica inmediata
D Colangiografía intraoperatoria
E Antibióticos y drenaje percutáneo

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Solicitar ecografía abdominal (opción A). Solicitar ecografía abdominal.

▶ VER CLASE 1.06.2.004 **Colecistitis aguda** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 4.1 · Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Dolor persistente (>6 h) en hipocondrio derecho con fiebre, signo de Murphy y leucocitosis; casi siempre por cálculo enclavado en el bacinete o cístico.
- Ecografía confirma: cálculo enclavado, Murphy ecográfico, pared >4 mm y líquido perivesicular.
- Manejo inicial: hospitalizar, régimen cero, hidratación, analgesia y antibióticos (ceftriaxona + metronidazol).
- Es la única del grupo que se opera de urgencia: colecistectomía laparoscópica precoz (<72 h).
- Paciente muy frágil o de alto riesgo quirúrgico: colecistostomía percutánea transitoria.
- Seguimiento: derivar a cirugía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 48 años con 8 horas de dolor intenso y continuo en hipocondrio derecho, fiebre de 38,5 °C y vómitos. Murphy positivo. Leucocitos 15.000/mm³, PCR elevada, bilirrubina normal. Ecografía: colelitiasis, pared vesicular de 6 mm y líquido perivesicular. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Analgesia y colecistectomía electiva en 6 semanas
B Colangiorresonancia y luego CPRE
C Hospitalizar, antibióticos y colecistectomía laparoscópica precoz
D CPRE urgente para drenaje biliar
E Ácido ursodesoxicólico y control ecográfico

Respuesta C. Dolor persistente + fiebre + Murphy + pared engrosada y líquido perivesicular: colecistitis aguda. La bilirrubina normal la separa de la coledocolitiasis y la colangitis. Es la única patología biliar que se opera de urgencia: colecistectomía laparoscópica en las primeras 72 horas.

▶ VER CLASE **1.06.2.005** **Diarrea aguda** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.2 · Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

QUÉ HAY QUE SABER

- Más de 3 deposiciones al día de menor consistencia por <2 semanas; casi siempre infecciosa y viral, diagnóstico clínico.
- Evaluar deshidratación: plan A (<5 %) SRO 100–200 mL tras cada deposición en casa; B (5–10 %) SRO 50–100 mL/kg en 4–6 h; C (>10 % o shock) cristaloides EV (SF 20 mL/kg en bolo en niños).
- No usar loperamida en disentería ni en niños; sí antieméticos si vomita.
- Antibiótico solo si disentería (Shigella, E. coli enteroinvasora), diarrea del viajero, fiebre alta >2–3 días o sepsis: ciprofloxacino oral (ceftriaxona EV si es grave); cólera o Campylobacter: azitromicina. Salmonella no complicada: sin antibiótico.
- Coprocultivo si hay disentería, inmunosupresión, brote o persiste; tras antibióticos, C. difficile.
- Seguimiento completo: control según evolución; si dura >2 semanas estudiar (coprocultivo, parasitológico seriado).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 30

Un paciente de 34 años lleva 48 horas con dolor abdominal tipo cólico, que ha ido en aumento, asociado a deposiciones líquidas abundantes y sensación febril. Al examen físico tiene temperatura axilar de 37,1 °C, frecuencia cardíaca de 80, presión arterial 120/80, dolor a la palpación del abdomen, mayor en la fosa ilíaca derecha, sin signo de Blumberg. Una ecografía abdominal muestra inflamación del íleon distal y del colon derecho, y el apéndice con leve edema de la pared y un coprolito en su base. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Apendicitis aguda
B Enteritis infecciosa
C Diverticulitis aguda
D Enfermedad de Crohn
E Colitis isquémica

Respuesta B. El dolor en fosa ilíaca derecha con diarrea, fiebre baja y sin signo de Blumberg, con inflamación difusa del íleon y del colon derecho en la ecografía (no solo del apéndice), orienta a una enteritis infecciosa que compromete la zona ileocecal; el edema leve del apéndice y el coprolito son un hallazgo acompañante, no el foco principal.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 34 años con 2 días de diarrea con sangre, dolor cólico y fiebre de 39 °C. Hemodinámicamente estable, tolera líquidos por boca, sin signos de deshidratación. **Además de la hidratación oral, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Loperamida oral
B Ciprofloxacino oral
C Solo sales de rehidratación, sin otros fármacos
D Colonoscopía urgente
E Vancomicina oral

Respuesta B. Disentería (sangre en las deposiciones) es una de las indicaciones de antibiótico en la diarrea aguda: ciprofloxacino oral, o ceftriaxona endovenosa si es grave. La loperamida está contraindicada. La vancomicina es para C. difficile, que exige uso previo de antibióticos.

▶ VER CLASE **1.06.2.006** **Encefalopatía hepática** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.3 · Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome neuropsiquiátrico del cirrótico: desde alteraciones del sueño y desorientación hasta coma; asterixis (temblor en aleteo) es el signo clásico. Diagnóstico clínico.
- Buscar siempre el precipitante: infección (el más frecuente, incluida PBE), HDA, constipación, sedantes, diuréticos, hipokalemia, deshidratación.
- Estudio: hemograma, electrolitos, función renal, glicemia, paracentesis diagnóstica si hay ascitis, hemocultivos; el amonio no es indispensable.
- Tratamiento: corregir el precipitante y lactulosa titulada a 2–3 deposiciones blandas al día (oral o enemas); agregar rifaximina en recurrencias.
- Proteger la vía aérea si hay compromiso de conciencia grave; no restringir proteínas. El TIPS está contraindicado en encefalopatía.
- Seguimiento: derivar a hepatología para evaluar trasplante.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 123

Paciente con antecedente de daño hepático crónico por alcohol presenta desorientación, lenguaje incoherente y tendencia a la somnolencia. Al examen físico tiene ictericia, arañas vasculares en la cara y el pecho, asterixis y compromiso cualitativo de conciencia. **¿Qué fármaco es el más adecuado para su tratamiento?**

A Amonio
B N-acetilcisteína
C Risperidona
D Donepezilo
E Lactulosa

Respuesta E. Compromiso de conciencia con asterixis en un cirrótico es una encefalopatía hepática. Se trata con lactulosa, buscando 2 a 3 deposiciones blandas al día, y corrigiendo el factor desencadenante: infección, hemorragia digestiva, trastorno electrolítico o constipación. La amonemia orienta el diagnóstico; no es un tratamiento.

▶ VER CLASE 1.06.2.007 Hemorragia digestiva alta y baja

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 5.3 · Hemorragia Digestiva Alta y Baja

QUÉ HAY QUE SABER

- Alta (proximal al ángulo de Treitz): hematemesis y melena. Baja: hematoquecia o rectorragia; una HDA masiva también puede dar hematoquecia.
- La gravedad la marca la hemodinamia (taquicardia, ortostatismo, hipotensión), no el hematocrito, que cae horas después.
- Manejo inicial: dos vías venosas gruesas, cristaloides, régimen cero; transfundir si hay anemia persistente tras reponer o sangrado masivo (meta Hb ~7). Endoscopía cuando el paciente esté estable.
- Úlcera péptica (causa más frecuente de HDA): IBP EV en dosis altas + endoscopía con hemostasia según Forrest; luego erradicar H. pylori.
- Várices (cirrótico): terlipresina + ceftriaxona (profilaxis de PBE) + ligadura endoscópica en <12 h; tiamina si es alcohólico.
- HDB: estable colonoscopía en 24 h; inestable endoscopía alta (10 % son altas), angio-TAC o angiografía. Causas: divertículos, angiodisplasia, cáncer, colitis isquémica. Seguimiento: derivar.

PREGUNTAS · 11

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 156

Un paciente de 45 años, luego de una transgresión alcohólica y alimentaria, presenta múltiples episodios de vómitos alimentarios, seguidos de hematemesis en una oportunidad. Su hemograma muestra hemoglobina de 9 gramos por decilitro. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Várices esofágicas
B Gastropatía erosiva
C Úlcera péptica activa
D Síndrome de Mallory-Weiss
E Gastritis isquémica

Respuesta D. Vómitos alimentarios intensos seguidos de hematemesis, sin enfisema ni sepsis, es el síndrome de Mallory-Weiss: un desgarro de la mucosa esofágica por el esfuerzo del vómito. No lo confundas con el síndrome de Boerhaave, que es una perforación transmural con mediastinitis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 148

Paciente de 55 años con múltiples episodios de hematemesis, cerca de un litro, en la última hora. Al examen: palidez de piel y mucosas, FC 120/min, PA 80/60 mmHg, estigmas de daño hepático crónico, abdomen blando y sensible. **¿Cuál es la conducta inicial?**

A Administrar terlipresina endovenosa
B Administrar cristaloides endovenosos
C Instalar balón de Sengstaken
D Realizar endoscopía digestiva alta
E Transfundir glóbulos rojos

Respuesta B. Hemorragia digestiva alta variceal masiva, con hipotensión y taquicardia: la conducta inicial, antes que cualquier otra cosa, es reponer volumen con cristaloides. La terlipresina y la endoscopía se dan de inmediato después, pero primero se estabiliza al paciente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 40

Una paciente de 19 años acude al servicio de urgencia por un cuadro de rectorragia de dos días de evolución, que el día de hoy se volvió mucho más abundante. Al examen físico tiene FC 117x', PA 90/60 mmHg, palidez de piel y mucosas y examen abdominal con dolor difuso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. Al preguntar dirigidamente, refiere antecedente de varios episodios de dolor periumbilical recurrente, de tipo urente, que había cedido de manera espontánea. Se solicita hemograma, que muestra hematocrito 27 %, hemoglobina 8,1 g/dL, blancos 5.000/mm³ y plaquetas 230.000/mm³. También se realiza colonoscopía de urgencia que muestra abundante sangre en todo el trayecto colónico, que fluye, además, por la válvula ileocecal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Enfermedad de Crohn

B Pólipo juvenil

C Infección por Shigella

D Divertículo de Meckel

E Adenitis mesentérica

Respuesta D. Paciente joven con rectorragia masiva y la colonoscopía muestra que la sangre viene desde el intestino delgado, por la válvula ileocecal, no del colon: eso aleja el colon como origen y apunta al divertículo de Meckel, la causa clásica de hemorragia baja masiva en el paciente joven.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 14

Un paciente de 52 años presenta hematoquecia de 2 días de evolución, sin otros síntomas. Sus signos vitales muestran PA 120/80 mmHg, FC 75x' y temperatura 36 °C. Al examen físico, tiene leve palidez de mucosas y su abdomen es blando y depresible, sin masas ni visceromegalia y con preservación de los ruidos hidroaéreos. Se solicita una colonoscopía, que es normal. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A Cintigrafía con glóbulos rojos marcados

B Endoscopía digestiva alta

C TAC de abdomen y pelvis

D Angiografía mesentérica

E Enteroscopía

Respuesta B. Hematoquecia con una colonoscopía normal: el paso siguiente es la endoscopía digestiva alta, por la regla del 10 por ciento, ya que un sangrado alto con tránsito acelerado puede manifestarse como sangre roja y hacer creer que el origen es bajo cuando en realidad no lo es.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 40

Paciente de 19 años que acude al servicio de urgencia por un cuadro de rectorragia de 2 días de evolución, que el día de hoy se volvió mucho más abundante. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca de 117 por minuto, presión arterial de 90/60 mm Hg, palidez de piel y mucosas, y examen abdominal con dolor difuso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. Al preguntar dirigidamente, refiere antecedente de varios episodios de dolor periumbilical recurrente, de tipo urente, que había cedido de manera espontánea. El hemograma muestra hematocrito 27 por ciento y hemoglobina 8,1 gramos por decilitro. La colonoscopía de urgencia muestra abundante sangre en todo el trayecto colónico, que fluye, además, por la válvula ileocecal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Enfermedad de Crohn

B Pólipo juvenil

C Infección por Shigella

D Divertículo de Meckel

E Adenitis mesentérica

Respuesta D. Hemorragia digestiva baja masiva, con sangre que fluye desde el íleon a través de la válvula ileocecal, en un paciente con episodios previos de dolor periumbilical urente que cedían solos (la diverticulitis que imita apendicitis, ya resuelta espontáneamente): divertículo de Meckel. El examen que lo confirma es la cintigrafía con pertecnetato de Tc-99m, que capta la mucosa gástrica ectópica que sangra.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 55 años con cirrosis por alcohol llega por vómito de abundante sangre roja. Pálido y sudoroso, FC 120/min, PA 85/50 mmHg. El hematocrito informado es de 38 %. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Esperar un hematocrito de control antes de decidir, ya que el actual es normal

B Transfundir glóbulos rojos como primera medida de reanimación

C Dos vías gruesas y cristaloides, terlipresina, antibióticos, tiamina y endoscopía con ligadura

D IBP endovenoso y endoscopía electiva en 72 horas

E Colonoscopía urgente

Respuesta C. HDA con compromiso hemodinámico (taquicardia e hipotensión) en un cirrótico: hemorragia variceal. La gravedad la define la hemodinamia; el hematocrito inicial es normal porque se pierde sangre completa. Reanimación con cristaloides, terlipresina, antibióticos (profilaxis de PBE), tiamina y ligadura endoscópica en las primeras 12 horas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Al momento de la presentación de una hemorragia digestiva alta. **¿Cuál de los siguientes parámetros determina mejor la gravedad del cuadro?**

A El hematocrito

B La hemoglobina

C La frecuencia cardíaca y la presión arterial

D El volumen estimado de la hematemesis

E El recuento de plaquetas

Respuesta C. En el sangrado agudo se pierde sangre completa, por lo que el hematocrito inicial suele ser normal y cae horas después, cuando el líquido intersticial diluye la masa eritrocitaria. La gravedad la marca el compromiso hemodinámico: taquicardia (lo más precoz), ortostatismo y, finalmente, hipotensión.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 147

Un paciente de 61 años, con antecedente de haberse realizado una colonoscopía, hace un mes, la que estaba normal, consulta por una hemorragia digestiva baja abundante, con compromiso hemodinámico. Su frecuencia cardiaca es 120x' y su presión arterial, 90/60 mmHg. Se realiza endoscopía digestiva alta, que resulta normal y su hemograma muestra hematocrito de 19%, con hemoglobina: 6,3 g/dl. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?

A Ecografía abdominal

B TAC de abdomen y pelvis

C Cintigrafía con glóbulos rojos marcados

D Colonoscopía

E Angiografía mesentérica

Respuesta D. La colonoscopía es el examen de elección para enfrentar la HDB. La EDA se hizo, porque tenía hemodinamia inestable (siempre se debe hacer en ese caso). No importa que hace un mes tuviese una colonoscopía normal. Si no localiza, se procede a la cintigrafía con GR marcados o a la angiografía mesentérica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 31

Una paciente diabética, presenta hematemesis en 3 oportunidades. Su frecuencia cardíaca es 117x', su presión arterial es 90/60 mmHg. Al examen físico presenta arañas vasculares en la cara, ictericia en las escleras, abdomen blando depresivo e indoloro, con signos de ascitis. Se solicitan exámenes que muestran bilirrubina total: 4,3 mg/dl, hematocrito: 39%, INR: 1,8. La causa más probable de su hemorragia digestiva es:

A Várices esofágicos

B Úlcera gastroduodenal

C Gastriris erosiva

D Síndrome de Mallory Weiss

E Esofagitis erosiva

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Várices esofágicos). Tiene clínica y exámenes de DHC, además de una HDA masiva, lo que orienta a várices esofágicos. Clase sobre el enfoque global de la ictericia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 84

Un paciente de 55 años, con antecedente de diabetes mellitus 2, consulta por un cuadro de hematemesis, seguida de malestar general. Al examen físico está pálido, con FC:110x', PA: 100/60 mmHg, constatándose obesidad. En sus exámenes destaca álbúmina: 3,0 g/dl; INR: 1,3; hematocrito: 30%, plaquetas: 77.000 por mm3, VCM: 105 fl y VHS: 20 mm/h. El diagnóstico más probable es:

A Síndrome de Mallory Weiss

B Úlcera gástrica

C Úlcera duodenal

D Várices esofágicas

E Gastriris crónica atrófica

Respuesta D. Son várices porque se presenta como hematemesis grave y los exámenes sugieren consumo de alcohol (VCM elevado) y daño hepático crónico (albúmina baja e INR levemente aumentado).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 114

Un paciente de 43 años acude al servicio de urgencia, luego de 7 días de ingesta alcohólica, porque presentó vómitos alimentarios intensos, seguidos de hematemesis. Al examen físico está en buenas condiciones, con dolor a la palpación epigástrica y en sus exámenes destaca hematocrito: 32%, GOT: 180UI/L, GPT: 130 UI/L, protrombinemia: 78%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Úlcera gástrica

B Úlcera duodenal

C Síndrome de Mallory Weiss

D Gastritis erosiva

E Várices esofágicas

Respuesta C. Parece una hepatitis por consumo de alcohol (aunque la relación GOT/GPT no alcanza a ser mayor a 2), que luego vomitó y siguió con un Mallory Weiss clásico (desgarro esofágico por vómitos).

▶ VER CLASE **1.06.2.008** **Hepatitis aguda A complicada** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.2 · Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Formas atípicas de la hepatitis A: colestásica prolongada, recurrente (bifásica) y fulminante (~0,1 %, más en adultos mayores y hepatópatas crónicos).
- Hepatitis fulminante: encefalopatía dentro de 8 semanas desde la ictericia en hígado previamente sano; marcador de gravedad TP/INR prolongado (INR >1,5), no la bilirrubina ni las transaminasas.
- Signos de alarma: compromiso de conciencia, asterixis, hipoglicemia, vómitos persistentes, ictericia progresiva con TP en descenso.
- Manejo inicial: hospitalizar, controlar glicemia, TP, función renal y conciencia seriados; soporte, evitar sedantes y hepatotóxicos.
- Seguimiento: derivar precozmente a centro con trasplante hepático; notificar y manejar contactos (inmunoglobulina + vacuna en convivientes).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 26

Mujer de 30 años con 10 días de astenia, fiebre, malestar y dolor epigástrico; hace 2 días ictericia y hoy orinas oscuras. FC 96/min, PA 100/60, ictericia franca, sin compromiso de conciencia, sin signos peritoneales. GOT 2.640 U/L, GPT 2.860 U/L, GGT 180, FA 412, protrombinemia 52 %, bilirrubina total 9,2 mg/dL (directa 6,6), albúmina 3,4 g/dL. IgM anti-VHA 5,5 U (VN < 0,2). **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Dieta blanda y reposo en domicilio

B Hospitalizar

C Solicitar ecografía abdominal y controlar de forma ambulatoria

D Solicitar colangiopancreatografía por resonancia magnética

E Indicar N-acetilcisteína oral

Respuesta B. Hepatitis A aguda con protrombinemia de 52 %. Sin encefalopatía aún no es fulminante, pero la caída del tiempo de protrombina es el marcador de gravedad y riesgo de progresión: obliga a hospitalizar. El manejo ambulatorio es para la hepatitis A no complicada con protrombina normal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 26

Una paciente de 30 años consulta por un cuadro de 10 días de evolución caracterizado por astenia, fiebre, malestar general y dolor epigástrico. Hace 2 días se agregó ictericia de piel y escleras, y hoy presentó orinas oscuras. Al examen físico tiene FC 96/min, PA 100/60 mmHg, ictericia franca de escleras y piel, sin alteraciones de conciencia. El abdomen es doloroso en epigastrio e hipocondrio derecho, sin signos peritoneales ni visceromegalia, con ruidos hidroaéreos conservados. Exámenes: GOT 2.640 UI/L, GPT 2.860 UI/L, GGT 180 UI/L, FA 412 UI/L, protrombinemia 52%, bilirrubina total 9,2 mg/dL, directa 6,6 mg/dL, albúmina 3,4 g/dL. IgM para virus hepatitis A: 5,5 UI (VN menor a 0,2). **¿Cuál es la conducta más adecuada con esta paciente?**

A Dieta blanda y reposo en domicilio

B Hospitalizar

C Solicitar ecografía abdominal y controlar ambulatoriamente

D Solicitar una colangiopancreatografía por resonancia magnética

E Indicar N-acetilcisteína oral

Respuesta B. Hepatitis A con protrombina de 52% es una hepatitis aguda grave: aun sin encefalopatía, tiene riesgo de progresar a insuficiencia hepática aguda, por lo que se hospitaliza para vigilar protrombina, glicemia y conciencia. La N-acetilcisteína es específica para paracetamol y la colangiorresonancia no aporta ante un patrón hepatocelular.

▶ VER CLASE **1.06.2.009** **Insuficiencia hepática aguda** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.2 · Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Falla hepática aguda: coagulopatía (INR ≥1,5) + encefalopatía en paciente sin hepatopatía previa, dentro de las 26 semanas del inicio.
- Causas: paracetamol (la principal en países desarrollados), virus (A, B, E en embarazadas), fármacos (antituberculosos), Amanita, hepatitis autoinmune, Wilson, isquemia, hígado graso agudo del embarazo.
- Sospechar ante hepatitis aguda con compromiso de conciencia, asterixis, ictericia progresiva, hipoglicemia o TP/INR en aumento.
- Manejo inicial: hospitalizar en UPC, glicemia y TP seriados, corregir hipoglicemia, evitar sedantes; N-acetilcisteína en intoxicación por paracetamol (útil incluso tarde) y suspender todo fármaco hepatotóxico.
- El TP/INR es también el criterio de derivación a trasplante.
- Seguimiento: derivar de inmediato a centro con trasplante hepático.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 28 años sin enfermedad hepática previa presenta ictericia de 10 días. Hoy su familia la nota somnolienta y desorientada, con asterixis. Exámenes: GPT 3.200 UI/L, bilirrubina total 12 mg/dL, INR 2,8, glicemia 62 mg/dL. HBsAg e IgM anti-core positivos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Manejo ambulatorio con control de pruebas hepáticas en 48 horas

B Hospitalizar en sala y administrar vitamina K hasta normalizar el INR

C Ingreso a UCI y contacto precoz con un centro de trasplante hepático

D Plasma fresco congelado para normalizar el INR antes de cualquier evaluación

E Corticoides en dosis altas

Respuesta C. Encefalopatía más INR de 1,5 o más en una paciente sin hepatopatía previa define insuficiencia hepática aguda, aquí por virus hepatitis B. Requiere UCI y contacto precoz con un centro de trasplante, además de antiviral. El plasma no se usa para corregir el INR sin sangrado porque oculta el pronóstico; la vitamina K no revierte una falla de síntesis.

▶ VER CLASE 1.06.2.010 Pancreatitis aguda

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 4.2 · Pancreatitis Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Causas en Chile: litiasis biliar (mujer, transaminasas y FA altas) y alcohol (varón); otras: TG >1.000 mg/dL, hipercalcemia, fármacos, post-CPRE.
- Diagnóstico con 2 de 3 criterios (Atlanta): dolor epigástrico en faja al dorso, lipasa o amilasa >3 veces el límite normal, imagen compatible. Con los dos primeros no se necesita TAC; TAC con contraste a las 72 h si hay duda o mala evolución.
- La cifra de lipasa no indica gravedad; sí predicen gravedad hematocrito y BUN en ascenso, BISAP, falla orgánica >48 h (grave).
- Manejo inicial: volumen agresivo precoz con Ringer lactato 5–10 mL/kg/h guiado por diuresis >0,5 mL/kg/h; analgesia con opioides; realimentación oral precoz (24–72 h) o enteral; sin antibióticos profilácticos.
- Estudiar causa en todos: ecografía abdominal, perfil lipídico y calcemia. Biliar con colangitis: CPRE urgente; biliar leve: colecistectomía en la misma hospitalización.
- Seguimiento: derivar; hospitalizar siempre.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 121

Un paciente de 45 años, sin antecedentes, consulta por dolor epigástrico intenso asociado a vómitos biliosos. Al examen físico se encuentra frecuencia cardiaca en 90 por minuto, presión arterial 140/90, escleras levemente ictéricas, abdomen blando, doloroso a palpación epigástrica, Blumberg negativo. Se solicitan exámenes que muestran GOT 100 U/L, GPT 110 U/L, bilirrubina total 2 mg/dL, fosfatasas alcalinas 350 U/L, lipasa 250 U/L. Ecografía abdominal que muestra vesícula de paredes delgadas, sin edema, con barro biliar visible y colédoco de 8 mm. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Colangitis aguda

B Pancreatitis aguda

C Coledocolitiasis

D Colecistitis aguda

E Cólico biliar simple

Respuesta B. La lipasa está sobre 180, tres veces el límite superior normal, junto con dolor típico: cumple criterios de pancreatitis aguda. Además tiene barro biliar y un colédoco levemente dilatado, sugerentes de coledocolitiasis, pero manda la pancreatitis por ser lo más grave. Sin fiebre ni compromiso hemodinámico no es colangitis, y la vesícula de paredes delgadas sin edema descarta la colecistitis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 90

Un paciente obeso, con antecedente de hígado graso, luego de una transgresión alimentaria con abundante consumo de alcohol presenta un cuadro de dolor epigástrico irradiado a ambos costados, asociado a vómitos alimentarios, sensación febril e ictericia. Al examen físico su presión arterial es de 110/70 mmHg, con frecuencia cardíaca de 100 por minuto, y al examen abdominal presenta dolor a la palpación de forma difusa, con abolición de ruidos hidroaéreos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Isquemia mesentérica

B Colangitis

C Pancreatitis

D Colecistitis

E Coledocolitiasis

Respuesta C. Dolor epigástrico intenso irradiado en faja a ambos costados, con vómitos, tras una transgresión alimentaria y alcohol, más íleo (ruidos hidroaéreos abolidos): pancreatitis aguda. Se confirma con lipasa o amilasa sobre 3 veces el valor normal. La ictericia puede acompañarla y no basta para pensar en colangitis.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 50 años, bebedor intenso, con pancreatitis aguda de 20 horas de evolución (lipasa 12 veces el valor normal). Está taquicárdico, con diuresis escasa. El hematocrito subió de 44 % al ingreso a 49 %. Temperatura 37,8 °C, leucocitos 14.000/mm³. **¿Cuál es la medida que más impacta en su pronóstico?**

A Iniciar imipenem profiláctico

B Reposición agresiva con Ringer lactato ajustada a diuresis

C Solicitar TAC de abdomen con contraste de inmediato

D Iniciar nutrición parenteral total

E Realizar CPRE urgente

Respuesta B. Hematocrito en ascenso, taquicardia y oliguria: está perdiendo volumen al tercer espacio y predice necrosis. La reposición precoz con Ringer lactato es lo que más reduce la mortalidad. No hay indicación de antibióticos profilácticos (la fiebre es inflamatoria), el TAC se pide a las 72 h, la parenteral se evita y la CPRE urgente es solo para la colangitis.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Paciente de 55 años con pancreatitis aguda biliar de 36 horas de evolución. Está hemodinámicamente estable, afebril, con dolor en disminución y tolera líquidos. Ecografía: colelitiasis, vía biliar de calibre normal, sin cálculos en el colédoco. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la vía biliar?**

A CPRE de urgencia en las próximas 24 horas

B Colecistectomía laparoscópica durante el mismo ingreso, una vez resuelto el episodio

C Alta con colecistectomía programada en 6 a 8 semanas

D Colangiorresonancia y luego CPRE si es positiva

E Manejo médico indefinido, sin cirugía, por el riesgo quirúrgico

Respuesta B. Pancreatitis biliar leve ya resuelta: colecistectomía laparoscópica en el mismo ingreso; diferirla se asocia a alta recurrencia de pancreatitis, colecistitis o colangitis. La CPRE urgente es solo para colangitis u obstrucción persistente, y la colangiorresonancia no aporta con baja probabilidad de coledocolitiasis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 35

Un paciente presenta dolor epigástrico muy intenso, irradiado a ambos costados, . Tiene antecedente de una transgresión alimentaria y consumo de alcohol, el día anterior. Al examen físico se aprecia adolorido, con temperatura 38 grados, abdomen difusamente doloroso a la palpación, con disminución de los ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

A Úlcera perforada

B Isquemia mesentérica

C Hepatitis

D Colecistitis aguda

E Pancreatitis aguda

Respuesta E. Diagnóstico: Pancreatitis aguda (opción E). Cuadro clásico.

▶ VER CLASE 1.06.2.011 **Peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.3 · Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Infección del líquido ascítico sin foco quirúrgico, monomicrobiana; agente más frecuente E. coli. Clínica puede ser mínima: fiebre, dolor abdominal o cualquier descompensación (encefalopatía, falla renal).
- Diagnóstico: paracentesis diagnóstica a todo cirrótico con ascitis que consulta o se hospitaliza; PMN ≥250/mm³ en el líquido confirma (cultivo en frascos de hemocultivo).
- Tratamiento: cefotaxima o ceftriaxona EV por 5–7 días; no usar aminoglucósidos (nefrotóxicos).
- Albúmina EV 1,5 g/kg el día 1 y 1 g/kg el día 3: previene el síndrome hepatorrenal y reduce mortalidad.
- Diferenciar de peritonitis secundaria (polimicrobiana, perforación): requiere cirugía, la PBE no.
- Profilaxis secundaria con ciprofloxacino (o norfloxacino) indefinida mientras haya ascitis; primaria si albúmina en líquido <1,5 g/dL o HDA. Seguimiento: derivar a hepatología (evaluar trasplante).

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 159

Paciente de 67 años, cirrótico por alcohol, traído por deterioro del estado general y compromiso de conciencia. Está en sopor superficial, con fetor hepático, temperatura de 38,3 y frecuencia cardíaca de 85. El abdomen muestra ascitis a tensión, con asterixis y sin focalidad neurológica. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?**

A Hemocultivos
B Hemograma
C Estudio de líquido ascítico
D TAC de abdomen
E Ecografía abdominal

Respuesta C. Todo cirrótico con ascitis que se descompensa debe estudiarse primero para descartar una peritonitis bacteriana espontánea, con paracentesis y recuento de polimorfonucleares en el líquido ascítico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 98

Paciente de 55 años, con daño hepático crónico por virus hepatitis C, consulta por malestar general, febrículas, confusión y aumento del perímetro abdominal. Al examen: matidez desplazable. Paracentesis diagnóstica: transudado con 300 leucocitos por mm³, 100 % polimorfonucleares. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Administrar albúmina endovenosa
B Realizar paracentesis evacuadora
C Observar
D Administrar antibióticos de forma empírica
E Iniciar terapia con furosemida y espironolactona

Respuesta D. Trescientos leucocitos, cien por ciento polimorfonucleares en el líquido ascítico: peritonitis bacteriana espontánea. También corresponde dar albúmina, pero lo prioritario y lo que define la pregunta es iniciar antibióticos empíricos de inmediato, con cefotaxima.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 129

Paciente cirrótico hospitalizado con ascitis en tratamiento con cefotaxima por PBE. A las 72h persiste fiebre y deterioro. Cultivo del líquido ascítico: Escherichia coli. ¿Cuál es el significado clínico?

A E. coli es el agente más frecuente en PBE; el tratamiento es correcto si hay sensibilidad
B Cambiar a ceftriaxona
C Agregar metronidazol
D Cambiar a vancomicina
E Realizar paracentesis evacuadora urgente

Respuesta A. coli es el microorganismo más frecuente en PBE (40-50% de los casos). Si el antibiograma confirma sensibilidad a cefotaxima, el tratamiento es correcto. La falta de respuesta obliga a revisar antibiograma y buscar complicaciones.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 115

Un paciente de 56 años, con antecedente de daño hepático crónico, por consumo de alcohol, consulta por obnubilación, asociado a dolor abdominal e ictericia. Al examen físico se observa quejumbroso y tiene desorientación temporoespacial, fiebre de 38,3°C, ascitis moderada, ictericia de piel y mucosas y asterixis. Se solicita un hemograma, que muestra leucocitos de 16.000, con recuento diferencial normal. Sus pruebas hepáticas muestran bilirrubina total: 5,2 mg/dl, albúmina: 2,8 g/dl, protrombinemia: 60%, GOT: 110 UI/L, GPT: 90 UI/L, GGT: 88 UI/L, FA: 120 UI/L. Child-Pugh categoría C. La conducta más adecuada en este paciente es:

A Solicitar amonemia
B Realizar laparoscopía exploradora
C Iniciar lactulosa oral
D Recuento de polimorfonucleares en líquido ascítico
E Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Respuesta D. Esta es una pregunta que se ha repetido en múltiples ocasiones, con distintos enunciados y que se resumen en: "paciente con ascitis que le pasa cualquier cosa (ej. dolor, fiebre, desorientación, compromiso hemodinámico, HDA, etc.), lo primero a hacer es puncionarlo, para descartar PBE. Por tanto, la respuesta es el recuento de polimorfonucleares en la paracentesis diagnóstica (si es más de 250 por mm3 se confirma la PBE y se inicia cefotaximo ev más albúmina, prohibiendo la evacuación de la ascitis).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 117

Un paciente de 55 años, alcohólico, con daño hepático crónico, es traído al servicio de urgencia por deterioro del estado general, dolor abdominal y fiebre de 38,5 grados Celsius. Al examen físico está quejumbroso, en sopor, con dolor a la palpación abdominal y ascitis severa. Se solicita un hemograma que muestra hemoglobina 15 mg/dl, blancos de 15.000 por mm3 y plaquetas de 190.000 por mm3 y sus pruebas hepáticas muestran un daño hepático crónico en etapa C de Child Pugh . ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio de este paciente?

A Ecografía abdominal
B TAC de abdomen y pelvis
C Colangioresonancia
D Estudio de líquido ascítico
E Endoscopía digestiva alta

Respuesta D. Probablemente tiene una PBE, que lo descompensa. De todos modos, todo cirrótico descompensado, con ascitis, debe estudiarse para descartar la PBE (peritonitis bacteriana espontánea).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 39

Hombre con ascitis a tensión y fiebre y encefalopatía: a. Estudio liquido

A Staphylococcus aureus
B Streptococcus pneumoniae
C Escherichia coli
D Pseudomonas aeruginosa
E Klebsiella pneumoniae

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Staphylococcus aureus).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 175

Un paciente con antecedente de cirrosis hepática por consumo de alcohol, suspendido hace algún tiempo, hipertensión arterial, diabetes mellitus y tabaquismo, consulta por un cuadro de 7 días de evolución, caracterizado por desorientación, dolor abdominal, vómitos e ictericia. Al examen físico, presenta desorientación y lentitud del lenguaje, tiene frecuencia cardíaca: 89x', presión arterial 100/60 mmHg y asterixis. Al examen abdominal se evidencia ascitis grado 2 y dolor a la palpación abdominal. Sus pruebas hepáticas muestran: GOT 192 U/L, GPT 107 U/L, bilirrubina total 4 mg/dL y GGT 220 U/L. La protrombinemia es del 60%. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada para continuar con el estudio?

A Solicitar amonemia
B Solicitar TAC de cerebro
C Solicitar endoscopía digestiva alta
D Realizar paracentesis diagnóstica
E Solicitar ecografía abdominal

Respuesta D. Evaluación de la Descompensación en Pacientes Cirróticos con Ascitis: En pacientes cirróticos con ascitis que experimentan cualquier tipo de descompensación, la evaluación diagnóstica debe comenzar con una paracentesis diagnóstica para descartar la peritonitis bacteriana espontánea.

▶ VER CLASE **1.06.2.012** **Síndrome hepatorrenal** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 1.4 · Síndrome Cardiorrenal y Síndrome Hepatorrenal

QUÉ HAY QUE SABER

- Falla renal funcional en cirrótico avanzado con ascitis: vasodilatación esplácnica, hipovolemia arterial efectiva y vasoconstricción renal intensa; riñón estructuralmente sano.
- Sospechar ante alza de creatinina ≥0,3 mg/dL en 48 h o ≥50 % sobre la basal, oliguria, sodio urinario muy bajo y sedimento normal; gatillado por PBE, HDA, diuréticos o paracentesis sin albúmina.
- Diagnóstico de exclusión: sin mejoría tras 48 h sin diuréticos y con albúmina 1 g/kg/día (máx. 100 g), sin shock, sin nefrotóxicos (AINE, aminoglucósidos, contraste) y sin daño parenquimatoso (proteinuria <500 mg/día, sin hematuria).
- Manejo inicial: suspender diuréticos y nefrotóxicos, expandir con albúmina y tratar el gatillante.
- Tratamiento: terlipresina + albúmina (noradrenalina + albúmina en UCI). La única terapia curativa es el trasplante hepático.
- Seguimiento: derivar a hepatología/UPC.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años con cirrosis alcohólica y ascitis, usuario de espironolactona 100 mg y furosemida 40 mg/día. Consulta por astenia y oliguria. Creatinina 2,4 mg/dL (basal 0,9 hace 3 semanas), Na urinario 8 mEq/L, sedimento normal. Se suspenden los diuréticos y se administra albúmina 1 g/kg/día por 48 horas; la creatinina sube a 2,7 mg/dL. **¿Cuál es el tratamiento de elección en este momento?**

A Terlipresina IV más albúmina al 20 %

B Reiniciar furosemida en dosis altas

C Hemodiálisis de urgencia

D Suero fisiológico 2 litros en bolo

E Paracentesis evacuadora de 8 litros sin reposición

Respuesta A. Cirrosis con ascitis, injuria renal aguda, sedimento normal, Na urinario bajo y sin respuesta a 48 h de albúmina tras suspender diuréticos: síndrome hepatorrenal. Tratamiento médico de elección: terlipresina + albúmina al 20 %, como puente al trasplante hepático.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 52 años con cirrosis Child-Pugh C por virus de hepatitis C y ascitis refractaria, hospitalizado por hemorragia digestiva alta variceal resuelta con ligadura. A las 72 horas presenta oliguria con creatinina de 0,8 a 2,6 mg/dL. Se suspenden diuréticos y se infunde albúmina al 20 % a 1 g/kg/día por 48 horas; la creatinina se mantiene en 2,5 mg/dL. Sedimento sin cilindros ni proteinuria. Na urinario 6 mEq/L. PA 100/60 mmHg. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A Hemodiálisis trisemanal ambulatoria

B Terlipresina intravenosa asociada a albúmina

C Infusión de dopamina a dosis renales vasodilatadoras (2 mcg/kg/min)

D Bolo de furosemida de 120 mg IV

E Paracentesis evacuadora total de 8 litros sin reposición

Respuesta B. Cirrosis con ascitis, injuria renal aguda, oliguria con Na urinario < 10, sedimento inactivo y sin respuesta a 48 h de albúmina: síndrome hepatorrenal. Primera línea: terlipresina + albúmina IV, como puente al trasplante hepático.

Conocimientos generales

6 códigos

▶ VER CLASE 1.06.3.001

Vacunación de hepatitis A y B

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.3 · Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026

QUÉ HAY QUE SABER

- Hepatitis B: vacuna universal en el PNI, al nacer y luego en la hexavalente (2, 4, 6 y 18 meses). RN de madre AgHBs +: vacuna + inmunoglobulina anti-VHB antes de 12 h; la lactancia está permitida.
- Hepatitis B en adultos de riesgo: personal de salud, hemodiálisis, VIH, hepatopatía crónica, contactos sexuales o domiciliarios de portadores, HSH; esquema de 3 dosis (0, 1, 6 meses) y verificar anti-HBs en personal de salud.
- Hepatitis A: dosis única a los 18 meses en el PNI chileno; también en hepatópatas crónicos, viajeros y manipuladores de alimentos.
- Post exposición a hepatitis A: convivientes inmunoglobulina + vacuna; contactos extradomiciliarios (jardín, colegio) vacuna.
- Accidente cortopunzante con fuente AgHBs + en no inmunizado: inmunoglobulina + vacuna. El anti-HBs aislado indica inmunidad por vacuna.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de término, sano, cuya madre tiene antígeno de superficie del virus hepatitis B (HBsAg) positivo detectado en el control prenatal. **¿Cuál es la conducta más adecuada para prevenir la transmisión vertical?**

A Vacuna contra hepatitis B e inmunoglobulina anti-hepatitis B dentro de las primeras 12 horas de vida

B Solo vacuna hexavalente a los 2 meses según el calendario habitual

C Suspender la lactancia materna

D Inmunoglobulina anti-hepatitis B a los 2 meses

E Vacuna contra hepatitis A al nacer

Respuesta A. Al hijo de madre HBsAg positiva se le administra vacuna contra hepatitis B e inmunoglobulina específica dentro de las primeras 12 horas; luego completa el esquema y se controla serología posvacunal. Esto previene más del 90% de la transmisión. La lactancia no está contraindicada y esperar la hexavalente deja al niño desprotegido.

▶ VER CLASE 1.06.3.002

Manejo dietético en enfermos digestivos

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.3 · Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Celíaca: dieta sin gluten estricta y de por vida (sin trigo, cebada, centeno; avena con precaución por contaminación cruzada); alimentos certificados.
- Intolerancia a la lactosa: reducir lactosa según tolerancia, leche sin lactosa o lactasa; mantener aporte de calcio.

- Cirrosis: restricción de sodio (<2 g/día) si hay ascitis; no restringir proteínas (1,2–1,5 g/kg/día), colación nocturna; restricción hídrica solo con hiponatremia severa.
- Intestino irritable: dieta baja en FODMAP y fibra soluble; constipación: fibra 20–30 g/día y agua; diarrea aguda: hidratación y alimentación habitual precoz.
- Reflujo: fraccionar, evitar comidas copiosas y tardías, grasas, alcohol y café; pancreatitis: realimentación precoz; colelitiasis: régimen hipograso; pancreatitis crónica: enzimas con las comidas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 30 años con diagnóstico reciente de enfermedad celíaca, confirmada con anticuerpos antitransglutaminasa y biopsia duodenal. Consulta por orientación dietética. **¿Cuál de los siguientes alimentos puede consumir libremente?**

A Pan de centeno

B Arroz y maíz

C Cerveza de cebada

D Galletas de trigo integral

E Sémola de trigo

Respuesta B. La enfermedad celíaca se trata con una dieta estricta y de por vida libre de gluten: se excluyen trigo, cebada y centeno, y la avena contaminada. Arroz, maíz, papa, legumbres, carnes, frutas y verduras son naturalmente libres de gluten. En productos procesados conviene buscar el logo de alimento libre de gluten.

▶ VER CLASE 1.06.3.003 Epidemiología de los cánceres digestivos

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.5 · Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer gástrico: 1.ª causa de muerte por cáncer en hombres y 2.ª en mujeres en Chile; asociado a H. pylori, sal, ahumados, tabaco y familiar de primer grado.
- Cáncer de vesícula: Chile tiene una de las tasas más altas del mundo, ligado a colelitiasis (mujeres, ascendencia mapuche, obesidad); por eso GES de colecistectomía preventiva de 35 a 49 años.
- Cáncer colorrectal: en aumento; factores: edad >50, dieta rica en carnes rojas y procesadas, obesidad, sedentarismo, EII, antecedentes familiares y síndromes hereditarios.
- Cáncer de esófago: escamoso (tabaco, alcohol, cáusticos) y adenocarcinoma (ERGE, Barrett, obesidad). Hepatocarcinoma: cirrosis por VHB, VHC, alcohol, NASH.
- Cáncer de páncreas: tabaco, obesidad, diabetes, pancreatitis crónica; muy mal pronóstico.
- Los cánceres digestivos dan síntomas tardíos (baja de peso, anemia, hemorragia): la clave es la endoscopía precoz y los tamizajes.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En una reunión clínica de un CESFAM se revisa la epidemiología de los cánceres digestivos en Chile para priorizar la derivación de pacientes con epigastralgia. **¿Cuál es el cáncer digestivo que causa más muertes en hombres en Chile?**

A Cáncer colorrectal

B Cáncer de esófago

C Cáncer gástrico

D Cáncer de vesícula biliar

E Hepatocarcinoma

Respuesta C. El cáncer gástrico es la principal causa de muerte por cáncer digestivo en hombres chilenos, con mayor incidencia en el centro-sur del país; por eso existe el GES y la endoscopía precoz ante epigastralgia en mayores de 40 años. El cáncer de vesícula es característico de mujeres chilenas y el colorrectal va en aumento.

▶ VER CLASE 1.06.3.004 Métodos de tamizaje para cáncer de colon y hepatocarcinoma

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.5 · Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer colorrectal en riesgo promedio: tamizaje desde los 50 años con test de sangre oculta inmunoquímico anual o bienal, o colonoscopía cada 10 años.
- Test positivo: colonoscopía, que confirma y reseca adenomas (la secuencia adenoma-carcinoma tarda ~10 años).
- Sintomático o con alarma (anemia, constipación nueva, rectorragia): colonoscopía directa, no sangre oculta.
- Alto riesgo: familiar de primer grado con cáncer colorrectal, EII de 8–10 años (colonoscopía de vigilancia), poliposis adenomatosa familiar y Lynch (vigilancia intensiva desde edades tempranas).
- Hepatocarcinoma: ecografía abdominal cada 6 meses (± alfafetoproteína) en todo cirrótico y en portadores de VHB de alto riesgo, incluso si se erradicó el VHC.
- Nódulo sospechoso en la ecografía o AFP en alza: TAC o RM trifásica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 55 años, asintomático, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer ni de pólipos, consulta en su CESFAM para un examen preventivo. **¿Cuál es el método de tamizaje de cáncer colorrectal recomendado en este paciente?**

A Colonoscopía virtual por TAC cada 2 años

B Antígeno carcinoembrionario anual

C Test inmunológico de sangre oculta en deposiciones y, si es positivo, colonoscopía

D Tacto rectal anual

E Enema baritado cada 5 años

Respuesta C. En población de riesgo promedio desde los 50 años, el tamizaje en Chile se hace con test inmunológico de hemorragia oculta en deposiciones; si es positivo, colonoscopía. El CEA no sirve para tamizaje, solo para seguimiento del cáncer tratado. En hepatocarcinoma, en cambio, se tamiza al cirrótico con ecografía cada 6 meses.

▶ VER CLASE 1.06.3.005 Antiinflamatorios no esteroidales y tracto gastrontestinal

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.2 · Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori

QUÉ HAY QUE SABER

- Los AINE inhiben la COX y las prostaglandinas protectoras de la mucosa: dispepsia, erosiones, úlcera péptica (sobre todo gástrica), hemorragia y perforación; también lesiones de intestino delgado y colon.
- Factores de riesgo: edad >65 años, úlcera o HDA previa, dosis altas o varios AINE, uso conjunto de corticoides, anticoagulantes, antiagregantes o ISRS, y H. pylori.
- Prevención: usar la menor dosis por el menor tiempo; con riesgo, agregar IBP (omeprazol 20 mg/día) o usar inhibidor COX-2 (con precaución cardiovascular); erradicar H. pylori antes de AINE crónico.
- Úlcera por AINE: suspender el AINE e IBP por 8 semanas; si no se puede suspender, mantener IBP.
- Paracetamol como analgésico alternativo de menor riesgo digestivo; evitar AINE en cirróticos (falla renal) y en insuficiencia renal.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 161

Una paciente de 65 años, con antecedente de haber sido tratada de una úlcera duodenal hace 20 años, y de un infarto agudo al miocardio hace un año, utilizando aspirina 100 mg al día desde entonces, sufre un esguince de tobillo, por lo que se indica analgesia con diclofenco 100 mg cada 12 horas. En los días siguientes evoluciona con malestar general que va agravándose y se agrega disnea. Al examen físico presenta palidez mucocutánea, FC: 110x', PA: 110/66 mmHg, examen pulmonar normal y examen cardíaco que solo muestra taquicardia. Se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 7,5 g/dl, hematocrito: 23% VCM: 58 ft, plaquetas: 370.000 por mm3, ferritina: 12 ng/ml. El electrocardiograma muestra una taquicardia sinusal, sin signos actuales de isquemia. **¿Cuál es el examen para proseguir el estudio etiológico?**

A Prueba de antígeno en deposiciones para Helicobacter pylori

B Niveles de vitamina B12

C Biopsia de médula ósea

D Endoscopía digestiva alta

E Test de sangre oculta en deposiciones

Respuesta D. Ferropenia (VCM 58, ferritina 12) en una posmenopáusica con antecedente de úlcera duodenal que usa aspirina y diclofenaco: la sospecha es sangrado péptico. Se estudia con endoscopía digestiva alta, que además permite tratar la lesión.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 161

Una paciente de 65 años, con antecedente de úlcera duodenal tratada hace 20 años y de infarto agudo al miocardio hace un año, usa aspirina 100 mg al día desde entonces. Por un esguince de tobillo se indica diclofenaco 100 mg cada 12 horas. En los días siguientes evoluciona con malestar general progresivo y disnea. Al examen presenta palidez mucocutánea, FC 110/min, PA 110/66 mmHg, examen pulmonar normal y solo taquicardia al examen cardíaco. Hemograma: hemoglobina 7,5 g/dL, hematocrito 23%, VCM 58 fL, plaquetas 370.000/mm3, ferritina 12 ng/mL. El ECG muestra taquicardia sinusal, sin signos actuales de isquemia. **¿Cuál es el examen para proseguir el estudio etiológico?**

A Prueba de antígeno en deposiciones para Helicobacter pylori

B Niveles de vitamina B12

C Biopsia de médula ósea

D Endoscopía digestiva alta

E Test de sangre oculta en deposiciones

Respuesta D. Anemia ferropénica en una paciente que usa aspirina más un AINE y tiene antecedente de úlcera sugiere pérdida digestiva alta por lesión péptica inducida por AINE. La endoscopía digestiva alta diagnostica, permite terapia y en ella se biopsia para Helicobacter pylori. El antígeno fecal no localiza la lesión y la sangre oculta no cambia la conducta.

▶ VER CLASE 1.06.3.006 Esteatopatía no alcohólica

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.2 · Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Hígado graso metabólico (MASLD/NASH): la causa más frecuente de hepatopatía crónica, asociada a resistencia a la insulina, obesidad, DM2 y dislipidemia; sin consumo significativo de alcohol.
- Suele ser asintomático: transaminasas levemente elevadas con AST/ALT <1 y ecografía con hígado hiperecogénico ('brillante').
- Descartar otras causas: alcohol, virus B y C, fármacos, autoinmune, hemocromatosis.
- Evaluar fibrosis con índices no invasivos (FIB-4) o elastografía; la esteatohepatitis puede progresar a cirrosis y hepatocarcinoma.
- Tratamiento: bajar 7–10 % del peso con dieta y ejercicio, controlar diabetes, lípidos y PA; evitar alcohol. Las estatinas no están contraindicadas.
- Derivar si hay fibrosis avanzada o sospecha de cirrosis.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 102

Mujer con obesidad, que consume 2 a 3 copas de vino solo los fines de semana y está en tratamiento con estatinas, presenta transaminasas elevadas al doble del valor normal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Esteatohepatitis no alcohólica
B Esteatohepatitis alcohólica
C Hepatitis por fármacos
D Hepatitis por virus C
E Hepatitis autoinmune

Respuesta A. Obesidad con elevación leve de transaminasas y consumo de alcohol bajo el umbral de riesgo orienta a enfermedad hepática grasa no alcohólica, hoy llamada esteatosis asociada a disfunción metabólica. Las estatinas rara vez causan daño hepático relevante y no se suspenden por alzas menores a 3 veces el valor normal.

Exámenes e imagenología

15 códigos

▶ VER CLASE 1.06.4.001 Radiografía simple de abdomen

NIVEL **INTERPRETA Y EMPLEA**

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.4 · Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

QUÉ HAY QUE SABER

- Proyecciones de pie y acostado (o decúbito lateral); para buscar neumoperitoneo es mejor la radiografía de tórax de pie (aire bajo el hemidiafragma derecho).
- Obstrucción de intestino delgado: asas centrales dilatadas en escalera con válvulas conniventes y niveles hidroaéreos; colon: marco periférico dilatado con haustras que no cruzan todo el lumen.
- Vólvulo de sigmoides: asa en omega o 'grano de café' que nace de la fosa ilíaca izquierda; megacolon tóxico: colon transverso >6 cm.
- Otros hallazgos: calcificaciones (litiasis renal radiopaca, pancreatitis crónica), cuerpos extraños radiopacos, neumatosis intestinal en enterocolitis necrotizante.
- Utilidad limitada en dolor abdominal inespecífico; si no es concluyente, TAC de abdomen (zona de transición, viabilidad del asa).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 78 años, postrado y con constipación crónica, presenta distensión abdominal marcada, dolor cólico y ausencia de eliminación de gases y deposiciones de 2 días. La radiografía simple de abdomen muestra un asa colónica muy dilatada en forma de U invertida (grano de café), que nace en la pelvis y se proyecta hacia el hipocondrio derecho. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Íleo biliar
B Vólvulo de ciego
C Obstrucción de intestino delgado por bridas
D Megacolon tóxico
E Vólvulo de sigmoides

Respuesta E. El signo del grano de café, una U invertida que nace de la pelvis, es característico del vólvulo de sigmoides, típico de adultos mayores postrados y constipados. Sin signos de isquemia se intenta la devolvulación endoscópica. El vólvulo de ciego proyecta el asa hacia el hipocondrio izquierdo y el íleo biliar muestra aerobilia.

▶ VER CLASE 1.06.4.002 Tránsito esófago-estómago-duodeno

NIVEL **EMPLEA INFORME**

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.3 · Disfagia y Trastornos Motores del Esófago

QUÉ HAY QUE SABER

- Estudio radiológico con bario ingerido que evalúa la anatomía y el paso del contraste por esófago, estómago y duodeno.
- Indicado en disfagia alta (divertículo de Zenker: examen de elección), sospecha de acalasia ('pico de pájaro' con esófago dilatado), estenosis, anillos y hernia hiatal.
- No reemplaza a la endoscopía en disfagia lógica o sospecha de cáncer (la endoscopía permite biopsia).
- Si se sospecha perforación, usar contraste hidrosoluble y no bario (peritonitis/mediastinitis por bario).
- El médico general emplea el informe para orientar el diagnóstico y derivar.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 74 años consulta por disfagia alta de 1 año de evolución, regurgitación de alimentos no digeridos horas después de comer, halitosis y tos nocturna. Al deglutir se escucha un gorgoteo cervical. **¿Cuál es el examen inicial de elección para confirmar el diagnóstico?**

A Manometría esofágica de alta resolución

B Tránsito esófago-estómago-duodeno (esofagograma con bario)

C pH-metría de 24 horas

D TAC de cuello con contraste

E Endoscopía digestiva alta con biopsias

Respuesta B. La clínica sugiere un divertículo de Zenker. El esofagograma baritado lo demuestra como una bolsa posterior en la unión faringoesofágica y orienta la cirugía. La endoscopía no es el examen inicial porque al intubar a ciegas puede perforar el divertículo. La manometría es clave en la acalasia, no aquí.

▶ VER CLASE 1.06.4.003 Enema barritada

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.3 · Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

QUÉ HAY QUE SABER

- Estudio radiológico del colon con bario por vía rectal; hoy reemplazado en adultos por colonoscopía y colono-TAC.
- Utilidad clásica: Hirschsprung (zona de transición entre segmento agangliónico estrecho y colon dilatado; se confirma con biopsia rectal), colon 'en tubería' sin haustras en colitis ulcerosa, estenosis, divertículos y fístulas.
- Enema (neumático o hidrostático) guiado por imagen es tratamiento de primera línea en la invaginación intestinal del lactante, si no hay perforación ni peritonitis.
- Contraindicado en sospecha de perforación, megacolon tóxico y diverticulitis aguda; usar contraste hidrosoluble si hay riesgo de perforación.
- Lesión sospechosa en el enema: completar con colonoscopía y biopsia. El médico general emplea el informe.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 2 meses con constipación desde el nacimiento y eliminación de meconio después de las 48 horas de vida. Presenta distensión abdominal y, al tacto rectal, ampolla vacía con salida explosiva de deposiciones y gases. **Si se realiza un enema baritado, ¿qué hallazgo apoya el diagnóstico más probable?**

A Signo de la cuerda en íleon terminal

B Microcolon con imagen en miga de pan en íleon

C Zona de transición entre un recto estrecho y un colon proximal dilatado

D Imagen en muelle enrollado en colon transverso

E Colon completamente normal

Respuesta C. La sospecha es enfermedad de Hirschsprung. El enema baritado muestra el segmento distal agangliónico estrecho, una zona de transición y el colon proximal dilatado, con retención del contraste a las 24 horas. Se confirma con biopsia rectal sin células ganglionares. El muelle enrollado es de invaginación y el microcolon con miga de pan, del íleo meconial.

▶ VER CLASE 1.06.4.004 Colangiografía endoscópica

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 4.1 · Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis

QUÉ HAY QUE SABER

- CPRE: técnica endoscópica que opacifica la vía biliar y pancreática; hoy es principalmente terapéutica (papilotomía, extracción de cálculos, prótesis).
- Indicaciones: colangitis aguda (CPRE urgente para drenar), coledocolitiasis confirmada por colangiorresonancia o vista en la ecografía, pancreatitis biliar con colangitis u obstrucción persistente, paliación de ictericia obstructiva maligna.
- Para diagnóstico de la vía biliar se prefiere la colangiorresonancia, no invasiva.
- Complicaciones: pancreatitis post-CPRE (la más frecuente), hemorragia, perforación y colangitis.
- Tras la extracción de cálculos se indica colecistectomía electiva. El médico general emplea el informe.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 50 años con dolor en hipocondrio derecho e ictericia de 3 días, sin fiebre. Bilirrubina total 5 mg/dL, de predominio directo. La ecografía muestra colelitiasis y un colédoco de 12 mm con un cálculo de 8 mm en su porción distal. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la vía biliar?**

A Colangiorresonancia para confirmar el cálculo

B Ácido ursodesoxicólico

C Colecistectomía sola, sin tratar la vía biliar

D CPRE con papilotomía y extracción del cálculo, seguida de colecistectomía

E TAC de abdomen con contraste

Respuesta D. Si la ecografía ya demuestra el cálculo en el colédoco, la sospecha es alta y no se necesita colangiorresonancia: la CPRE es diagnóstica y terapéutica, con papilotomía y extracción. Luego se realiza la colecistectomía, idealmente en el mismo ingreso. La colangiorresonancia se reserva para la sospecha intermedia, sin cálculo visible.

▶ VER CLASE 1.06.4.005 TAC abdominal

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 4.2 · Pancreatitis Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- TAC de abdomen y pelvis con contraste EV: examen de elección en diverticulitis (Hinchey), complicaciones de pancreatitis, sospecha de tumor de páncreas, etapificación oncológica y abdomen agudo dudoso.
- Pancreatitis: no es necesario si hay dolor típico + lipasa >3 veces; indicado a las 72 h si hay duda o mala evolución (necrosis, colecciones).
- Obstrucción intestinal: identifica la zona de transición, la causa y signos de isquemia (gas en la pared o en la porta). Angio-TAC en isquemia mesentérica y hemorragia digestiva activa.
- Hepatocarcinoma: TAC trifásico con realce arterial y lavado portal.
- Precauciones: función renal (nefropatía por contraste), alergia al yodo, suspender metformina, radiación en embarazo. El médico general emplea el informe.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años ingresa con dolor epigástrico intenso irradiado en cinturón, lipasa 8 veces el valor normal y ecografía con colelitiasis. A las 12 horas está hemodinámicamente estable, con buena respuesta a la analgesia y a la hidratación. **¿Cuándo está indicada la TAC de abdomen con contraste en esta paciente?**

A De inmediato, para confirmar el diagnóstico

B Antes de iniciar la hidratación

C Siempre a las 24 horas, para calcular el índice de Balthazar

D Nunca, porque el contraste empeora la pancreatitis

E Solo si hay duda diagnóstica o mala evolución, idealmente después de 72 horas

Respuesta E. El diagnóstico ya está hecho con 2 de 3 criterios (dolor típico y lipasa sobre 3 veces lo normal), por lo que la TAC no se necesita al ingreso. Se pide ante duda diagnóstica o mala evolución, después de 72 horas, cuando la necrosis ya es evaluable y se puede calcular el índice de Balthazar.

▶ VER CLASE 1.06.4.006 Ecotomografía abdominal

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.1 · Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Primer examen en ictericia, dolor de hipocondrio derecho y masas hepáticas: barato, sin radiación, disponible.
- Vesícula: colelitiasis (imagen con sombra acústica), colecistitis (pared >4 mm, líquido perivesicular, Murphy ecográfico), pólipos (≥10 mm: colecistectomía).
- Vía biliar: colédoco >6–7 mm indica obstrucción (sospecha de coledocolitiasis; completar con colangiorresonancia); vía biliar dilatada sin dolor en adulto mayor sugiere tumor.
- Hígado: esteatosis (hiperecogénico), cirrosis (nodular, esplenomegalia, ascitis), lesiones focales (quiste anecogénico, hemangioma hiperecogénico); tamizaje semestral de hepatocarcinoma.
- Limitaciones: gas intestinal y obesidad; páncreas y colédoco distal mal visualizados (TAC si se sospecha masa pancreática). El médico general emplea el informe.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años con ictericia, coluria y prurito de 1 semana. Bilirrubina total 6 mg/dL, de predominio directo, con FA y GGT elevadas y transaminasas levemente alteradas. **¿Cuál es el primer examen de imagen que se debe solicitar?**

A Ecografía abdominal
B Colangiorresonancia
C CPRE
D TAC de abdomen con contraste
E Cintigrafía hepatobiliar

Respuesta A. Ante una ictericia con patrón colestásico, la ecografía abdominal es el primer examen: es barata, inocua y distingue la colestasia extrahepática (vía biliar dilatada) de la intrahepática (vía no dilatada), además de mostrar cálculos. Según su resultado se decide colangiorresonancia, TAC o CPRE.

▶ VER CLASE 1.06.4.007 Endoscopía digestiva alta y baja

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA

Gastroenterología 1.1 · Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett
Gastroenterología 1.2 · Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori
Gastroenterología 2.4 · Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn
Gastroenterología 5.3 · Hemorragia Digestiva Alta y Baja

QUÉ HAY QUE SABER

- Endoscopía alta: examen de elección con biopsias en dispepsia ≥40 años o con alarma (GES cáncer gástrico), disfagia lógica, HDA (diagnóstica y terapéutica), ingesta de cáustico (precoz, 12–24 h), cuerpo extraño esofágico y pesquisa de várices en cirróticos.
- Hallazgos clave: úlcera (duodenal erradicar; gástrica biopsiar y controlar), Barrett (metaplasia intestinal en biopsia), esofagitis, várices; HDA clasificada por Forrest (sangrado activo y vaso visible = alto riesgo).
- Colonoscopía: sintomáticos con alarma, test de sangre oculta positivo, tamizaje cada 10 años desde los 50, EII (colonoscopía con ileoscopía y biopsias) y vigilancia de pólipos.
- Contraindicadas en perforación (úlcera perforada, Boerhaave) y en diverticulitis aguda (colonoscopía a las 6–8 semanas).
- Preparación: ayuno para la alta; preparación de colon con polietilenglicol para la colonoscopía. El médico general emplea el informe.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 56 años con 2 años de pirosis que trata con omeprazol a demanda. Hace 2 meses siente que los sólidos se le quedan detenidos tras el esternón y ha bajado 5 kg. Hemoglobina 11,2 g/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Duplicar la dosis de omeprazol por 8 semanas
B Radiografía de tórax
C pH-metría esofágica de 24 horas
D Manometría esofágica
E Endoscopía digestiva alta con biopsias

Respuesta E. Disfagia, baja de peso, anemia e inicio después de los 50 años son signos de alarma: obligan a endoscopía digestiva alta con biopsias para descartar cáncer, Barrett o estenosis. Escalar el IBP sin estudiar retrasa el diagnóstico; la pH-metría y la manometría no muestran la mucosa.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 61 años consulta por melena. La endoscopía digestiva alta muestra una úlcera gástrica de 2 cm en la curvatura menor, sin sangrado activo. Las biopsias son negativas para neoplasia y el test de ureasa es positivo. Se indica erradicación de Helicobacter pylori y omeprazol. **¿Cuál es el seguimiento más adecuado?**

A Endoscopía digestiva alta de control con nuevas biopsias a las 8 a 12 semanas
B Test de aire espirado como único control
C Alta sin controles, ya que la biopsia fue negativa
D Serología para Helicobacter pylori a las 4 semanas
E TAC de abdomen a los 6 meses

Respuesta A. Toda úlcera gástrica se controla con endoscopía y nuevas biopsias a las 8–12 semanas hasta confirmar su cicatrización, porque una biopsia inicial negativa no descarta cáncer. Ese control permite además verificar la erradicación. La úlcera duodenal no complicada no requiere endoscopía de control.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 29 años con colitis ulcerosa conocida consulta por 10 deposiciones con sangre al día, fiebre de 38,6 °C y FC 115 por minuto. Abdomen distendido y sensible. La radiografía de abdomen muestra el colon transverso dilatado a 7 cm. **Respecto de la endoscopía, ¿cuál es la conducta correcta?**

A Colonoscopía total urgente para evaluar la extensión

B No realizar colonoscopía; hospitalizar con corticoides endovenosos y evaluación quirúrgica precoz

C Colonoscopía con biopsias para descartar citomegalovirus antes de tratar

D Enema baritado de doble contraste

E Endoscopía digestiva alta para descartar compromiso gástrico

Respuesta B. Es un megacolon tóxico: colon de más de 6 cm con toxicidad sistémica. La colonoscopía y el enema baritado están contraindicados por el alto riesgo de perforación. Se hospitaliza con régimen cero, corticoides endovenosos y evaluación quirúrgica precoz; a lo más, una rectoscopía cuidadosa con mínima insuflación.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 60 años, usuario de antiinflamatorios por artrosis, consulta por 2 episodios de melena. Al ingreso FC 110 por minuto y PA 100/60 mmHg; tras la reanimación con cristaloides, FC 88 por minuto y PA 120/70 mmHg. Hemoglobina 9,8 g/dL. Se inicia IBP endovenoso. **¿Cuál es el momento más adecuado para la endoscopía digestiva alta?**

A En forma electiva a las 4 a 6 semanas

B Inmediatamente, antes de iniciar la reanimación

C Dentro de las primeras 24 horas, una vez estabilizado

D Solo si vuelve a sangrar

E Después de una colonoscopía, para descartar origen bajo

Respuesta C. En la hemorragia digestiva alta no variceal la endoscopía se realiza dentro de las 24 horas, después de estabilizar: identifica la causa, permite terapia endoscópica y estratifica el riesgo de resangrado con la clasificación de Forrest. Endoscopiar sin reanimar aumenta las complicaciones; en la sospecha variceal se busca hacerla dentro de 12 horas.

▶ VER CLASE 1.06.4.008 Biopsia hepática

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.2 · Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Estándar para evaluar inflamación (grado) y fibrosis (estadio) en hepatopatías crónicas y para diagnóstico etiológico cuando los exámenes no invasivos no son concluyentes.
- Indicaciones: hepatitis autoinmune, colestasis de causa no aclarada, sospecha de NASH con fibrosis, enfermedades de depósito; hoy la elastografía la reemplaza en muchos casos.
- Contraindicaciones de la percutánea: coagulopatía (INR alto), trombocitopenia, ascitis importante (usar vía transyugular), sospecha de quiste hidatídico o lesión vascular.
- Complicaciones: dolor, hemorragia (la más grave), neumotórax, perforación biliar.
- El médico general emplea el informe para orientar el diagnóstico y derivar.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 52 años con hepatopatía crónica de causa no precisada pese a un estudio serológico completo. Se plantea biopsia hepática. Presenta ascitis moderada, INR de 1,9 y plaquetas de 60.000/mm3. **¿Cuál es la vía más adecuada para obtener la biopsia?**

A Percutánea guiada por ecografía

B Percutánea a ciegas tras transfundir plaquetas

C Laparotomía exploradora

D No está indicada; diagnosticar solo con transaminasas

E Transyugular

Respuesta E. La biopsia hepática percutánea está relativamente contraindicada con ascitis, INR mayor de 1,5 o plaquetas bajas, por riesgo de sangrado. En estos casos se usa la vía transyugular, que obtiene tejido desde la vena hepática sin perforar la cápsula y permite medir el gradiente de presión portal.

▶ VER CLASE 1.06.4.009 Sangre oculta en deposiciones

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.5 · Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje

QUÉ HAY QUE SABER

- Test inmunoquímico (FIT): detecta hemoglobina humana, sin restricción dietaria; de elección para tamizaje de cáncer colorrectal en riesgo promedio desde los 50 años (anual o bienal).
- Test de guayaco: afectado por carnes rojas, vitamina C y hierro; menor especificidad.
- Positivo: colonoscopía obligatoria; no repetir el test para 'confirmar'.
- No usar en sintomáticos o con alarma (anemia, rectorragia, cambio del hábito): ir directo a colonoscopía; tampoco para estudiar anemia ferropénica.

- Un resultado negativo no descarta cáncer: continuar el tamizaje periódico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 56 años, asintomático y sin antecedentes familiares de cáncer, participa en un programa de tamizaje de cáncer colorrectal. El test inmunoquímico de sangre oculta en deposiciones resulta positivo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Repetir el test en 1 año

B Repetir el test en 3 muestras más y decidir según el resultado

C Solicitar antígeno carcinoembrionario

D Colonoscopía completa

E Rectoscopía rígida

Respuesta D. Un test de sangre oculta positivo en tamizaje obliga a colonoscopía completa, que identifica pólipos o cáncer y permite resecar y biopsiar. Repetir el test o pedir CEA retrasa el diagnóstico, y el CEA no sirve para tamizaje. La rectoscopía solo explora el recto y no descarta lesiones proximales.

▶ VER CLASE 1.06.4.010 Estudio de perfil hepático

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.1 · Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Bilirrubina: ictericia visible sobre 2,5–3 mg/dL. Indirecta aislada: Gilbert (joven, resto normal, observar) o hemólisis (anemia, LDH alta). Directa >30 % del total: siempre patológica.
- Patrón hepatocelular: transaminasas (AST, ALT) predominantes; >1.000 UI/L: virus, paracetamol, isquemia. AST/ALT >2: alcohol; <1: NASH o virus.
- Patrón colestásico: FA y GGT elevadas; GGT confirma origen hepatobiliar (FA alta con GGT normal = hueso).
- Siguiente paso en colestasia: ecografía siempre primero; luego colangiorresonancia o TAC según la sospecha.
- Integrar con la clínica: colestasia con dolor = cálculo; con dolor + fiebre = colangitis; indolora en adulto mayor = cáncer.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 90

Una paciente de 26 años consulta por dispepsia de varios meses de evolución. Al examen físico se observa ictericia de piel y escleras. Tiene antecedente de alteraciones en sus pruebas hepáticas hace 2 años. Pruebas hepáticas: bilirrubina total 2,2 mg/dL, bilirrubina directa 0,3 mg/dL, GOT 26 UI/L, GPT 23 UI/L, GGT 46 UI/L, FA 65 UI/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Colangitis esclerosante primaria

B Síndrome de Gilbert

C Colestasia intrahepática

D Hepatitis en resolución

E Cirrosis biliar primaria

Respuesta B. Bilirrubina total elevada a expensas de la indirecta, con transaminasas, FA y GGT normales, en forma recurrente en una joven, es típico del síndrome de Gilbert, benigno y sin tratamiento. Las colestasias elevarían FA, GGT y bilirrubina directa, y una hepatitis elevaría las transaminasas. Debe descartarse hemólisis con hemograma.

▶ VER CLASE 1.06.4.011 Estudio de función hepática

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.3 · Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Evalúa la capacidad de síntesis del hígado: tiempo de protrombina/INR, albúmina; también bilirrubina, glicemia y amonio en la falla avanzada.
- TP/INR: el mejor marcador de gravedad en hepatitis aguda (INR ≥1,5 + encefalopatía = falla hepática aguda) y criterio de derivación a trasplante.
- Albúmina baja: síntesis disminuida (vida media ~20 días), refleja cronicidad; también baja en desnutrición y síndrome nefrótico.
- Child-Pugh (bilirrubina, albúmina, INR, ascitis, encefalopatía) y MELD (bilirrubina, INR, creatinina, sodio) estiman pronóstico.
- INR alto por vitamina K (colestasis, malabsorción) corrige con vitamina K parenteral; si no corrige, es falla de síntesis. No corregir el INR de rutina en cirróticos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Paciente de 45 años con cirrosis hepática conocida presenta una descompensación aguda. Se desea evaluar precozmente la capacidad de síntesis del hígado. **¿Cuál es el parámetro que refleja más rápidamente los cambios en la función de síntesis hepática?**

A Tiempo de protrombina o INR
B Albúmina plasmática
C Transaminasas (GOT y GPT)
D Fosfatasa alcalina
E GGT

Respuesta A. Los factores de coagulación tienen vida media de horas (el factor VII, cerca de 6 horas), por lo que el tiempo de protrombina o INR refleja precozmente la función de síntesis. La albúmina tiene vida media cercana a 20 días y cambia lentamente. Las transaminasas indican necrosis hepatocelular, y FA y GGT, colestasia.

▶ VER CLASE 1.06.4.012 Estudio de marcadores virales para hepatitis A, B y C

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.2 · Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Hepatitis A: IgM anti-VHA = infección aguda (primer examen en toda hepatitis aguda); IgG = infección pasada o vacuna.
- Hepatitis B: AgHBs = hay virus; IgM anti-HBc = es aguda. AgHBs + con IgM anti-HBc − = crónica (GES).
- AgHBs − con IgM anti-HBc + = período de ventana (sigue siendo aguda); anti-HBs + y anti-HBc IgG + = infección resuelta; anti-HBs aislado = inmune por vacuna (la vacuna no genera anti-HBc).
- AgHBe y ADN-VHB indican replicación e infectividad (seguimiento por especialista).
- Hepatitis C: anti-VHC como tamizaje; confirmar con ARN-VHC por PCR (anticuerpo + con PCR − = infección pasada resuelta).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 119

Hombre de 50 años, asintomático, se realiza pruebas hepáticas como parte de un chequeo médico, que muestran SGOT 332 UI/L y SGPT 210 UI/L, con bilirrubina de 1,5 mg/dL. No refiere hábitos tóxicos. Como antecedente, tuvo un hemoperitoneo traumático en 1992, que requirió transfusiones. **¿Qué examen se debe solicitar ante la sospecha diagnóstica?**

A Antígeno de superficie
B IgM para VHA
C Test de HOMA
D TAC de abdomen
E Anticuerpos totales contra VHC

Respuesta E. Transaminasas elevadas en un paciente transfundido antes de 1996, cuando en Chile aún no se tamizaba la sangre para virus C, obligan a buscar hepatitis C con anticuerpos totales anti-VHC; si son positivos, se confirma con carga viral. La IgM anti-VHA sirve para la hepatitis aguda, no para una infección crónica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 146

Una paciente de 27 años consulta por dolor abdominal de 5 días de evolución, asociado a malestar general, astenia y náuseas, a lo que recientemente se agrega ictericia. Al examen físico, destaca ictericia de escleras, pulso regular a 76x', PA: 110/70 mmHg, abdomen blando, depresible, pero con dolor a la palpación del epigastro e hipocondrio derecho, sin visceromegalia ni signos peritoneales. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran tiempo de protrombinemia: 70%, SGOT: 512 UI/L, SGPT: 356 UI/L, FA: 230 UI/l, GGT: 120 UI/L, albúmina: 3,8 g/dl, bilirrubina total: 4 mg/dl, con 35% de bilirrubina directa. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

A Ecografía abdominal
B TAC abdominal
C Endoscopía digestiva alta
D Colangiopancreatografía por resonancia magnética nuclear
E Serología para virus hepatitis

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Serología para virus hepatitis (opción E).

▶ VER CLASE 1.06.4.013 Laboratorio inicial de síndrome de malabsorción

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.3 · Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: diarrea crónica, baja de peso con ingesta conservada, esteatorrea y carencias.
- Exámenes generales: hemograma (anemia micro o macrocítica), ferritina, B12, folato, albúmina, calcio, fósforo, magnesio, vitamina D, colesterol bajo y TP prolongado (déficit de vitamina K).
- Sudán en deposiciones confirma esteatorrea; test de D-xilosa localiza: alterado = pared (celíaca, Crohn, intestino corto), normal = enzimas (pancreatitis crónica, fibrosis quística).
- Dirigidos: anti-transglutaminasa IgA con IgA total, parasitológico seriado (Giardia), elastasa fecal, test del sudor en niños con neumonías recurrentes.

- Confirmar causa con endoscopía y biopsia duodenal o imagen pancreática según el resultado.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 50 años con 5 meses de deposiciones voluminosas, pálidas y malolientes, que flotan y cuesta eliminar del inodoro, con baja de 7 kg. Usted sospecha un síndrome de malabsorción. **¿Cuál es el examen inicial más útil para confirmar la esteatorrea?**

A Sudán III en deposiciones o esteatocrito
B Coprocultivo
C Test de sangre oculta en deposiciones
D Leucocitos fecales
E Calprotectina fecal

Respuesta A. El primer paso ante sospecha de malabsorción es objetivar la esteatorrea con Sudán III o esteatocrito; el estándar es la grasa fecal de 72 horas. Luego se busca la causa: D-xilosa para distinguir mucosa de páncreas, serología celíaca y elastasa fecal. Calprotectina y leucocitos fecales miden inflamación, no grasa.

▶ VER CLASE 1.06.4.014 Determinación toxina C difficile en deposiciones

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.2 · Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado en diarrea (≥3 deposiciones líquidas/24 h) durante o tras uso de antibióticos, hospitalización prolongada, edad avanzada o IBP; solo en deposiciones diarreicas.
- Métodos: PCR del gen de la toxina o antígeno GDH + toxina A/B por inmunoensayo; alta sensibilidad de la PCR.
- Positivo con clínica compatible: infección por C. difficile; tratar con vancomicina oral (o metronidazol en casos leves según la clase) y suspender el antibiótico gatillante.
- No pedir en deposiciones formadas ni como test de curación (no se hace PCR de control); los portadores asintomáticos no se tratan.
- Gravedad: leucocitosis >15.000, creatinina >1,5 mg/dL, colitis pseudomembranosa o megacolon tóxico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 178

Un paciente de 65 años estuvo hospitalizado por una neumonía y, al cuarto día después del alta, inicia dolor abdominal asociado a diarrea acuosa, malestar general e incontinencia fecal, que han ido empeorando en los 7 días siguientes. Al examen tiene abdomen distendido, doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal y con ruidos hidroaéreos aumentados. **¿Cuál es el examen de elección para el estudio inicial de este paciente?**

A Colonoscopía
B Coprocultivo
C Recuento de leucocitos fecales
D Parasitológico de deposiciones
E Toxinas A y B de Clostridioides difficile en deposiciones

Respuesta E. Diarrea acuosa tras una hospitalización con antibióticos sugiere Clostridioides difficile. El estudio inicial es la detección de toxinas A y B o PCR en deposiciones, a menudo junto con GDH. El coprocultivo habitual no detecta toxinas y la colonoscopía se reserva para casos dudosos o graves. El tratamiento actual es vancomicina o fidaxomicina oral.

▶ VER CLASE 1.06.4.015 Colangiografía por resonancia magnética

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 4.1 · Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Estudio no invasivo de elección para visualizar la vía biliar y pancreática, sin radiación ni contraste yodado.
- Indicación: sospecha de coledocolitiasis (colédoco dilatado >6–7 mm en ecografía o patrón colestásico con dolor) cuando la ecografía no muestra el cálculo; estenosis biliares, colangitis esclerosante, tumores de la vía biliar.
- Confirma el cálculo y orienta la CPRE terapéutica; si la ecografía ya ve el cálculo o hay colangitis, se va directo a CPRE.
- Contraindicaciones: marcapasos o implantes metálicos no compatibles, claustrofobia.
- El médico general emplea el informe para derivar a cirugía o gastroenterología.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 48 años, colecistectomizada hace 2 años, consulta por dolor intermitente en hipocondrio derecho. Afebril, sin ictericia. Exámenes: bilirrubina total 1,8 mg/dL, FA 280 UI/L, GGT 310 UI/L. La ecografía abdominal muestra un colédoco de 8 mm sin cálculos visibles. **¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?**

A Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE)

B Repetir ecografía en 6 meses

C Colangiorresonancia

D TAC de abdomen sin contraste

E Exploración quirúrgica de la vía biliar

Respuesta C. Colédoco dilatado y colestasia, sin cálculo visible ni colangitis, configuran un riesgo intermedio de coledocolitiasis: corresponde colangiorresonancia, no invasiva y muy sensible. La CPRE se reserva para riesgo alto o cálculo confirmado, por su riesgo de pancreatitis. La TAC sin contraste es poco sensible para cálculos coledocianos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 96

Un paciente de 35 años, colecistectomizado hace 6 meses por vía laparoscópica, consulta por dolor epigástrico, progresivo, que inició hace 24 horas y que se ha asociado a ictericia y acolia. Al examen físico está afebril, con FC: 80x' y PA: 120/76 mmHg y se aprecia dolor a la palpación del hemiabdomen superior e ictericia de piel y mucosas. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran GOT: 45 UI/L, GPT: 52 UI/L, FA: 430 UI/L, GGT: 566 UI/L, bilirrubina de 6,4 mg/dl y TP: 88%. ¿Cuál es el examen de elección para establecer el diagnóstico?

A TAC de abdomen

B Ecografía abdominal

C Resonancia magnética nuclear abdominal

D Colangioresonancia

E Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Respuesta D. Es una pregunta difícil y discutible. El diagnóstico más probable es una coledocolitiasis. Suele iniciarse con ecografía. De elección para el diagnóstico la colangioRMN (por eso la dejamos como respuesta correcta). Sirve, además, como examen no solo diagnóstico, sino terapéutico, la CPRE (la que se pide si 1. la ecografía ve cálculos en el colédoco [no en la vesícula], 2. la CPRE confirma el diagnóstico o 3. la clínica es de colangitis).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 73

Un paciente de 40 años, con antecedente de colecistectomía laparoscópica hace un año por colelitiasis, consulta por cuadro de 24 horas de dolor abdominal asociado a vó- mitos e ictericia. Su perfil hepático muestra GOT: 42UI/L, FA: 450mg/dL, bilirrubina total es de 10,3mg/dL, con bilirrubina directa de 9,5 mg/dL. Se realiza una ecografía abdomi- nal que muestra dilatación de la vía biliar principal, sin visualización de cálculos. El examen de elección para continuar el estudio es:

A Colangioresonancia

B Colangiografía endoscópica

C TAC de abdomen y pelvis

D Exploración quirúrgica

E Marcadores tumorales

Respuesta A. A, B? La sospecha es una coledocolitiasis residual y la verdad es que no existe una única forma de enfrentarla. La evidencia no es clara y las recomendaciones son muy variables. Por un lado, la conlangioresonancia da mucha información y en el algún mo- mento, la sociedad chilena de cirugía la recomendó antes que la CPRE, por tener menos efectos adversos y poder diferencias aquellos pacientes que se benefician de la CPRE de aquellos que requieren otro tratamiento. Sin embargo para muchos, la...

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

1 códigos

▶ VER CLASE 1.06.5.001 **Paracentesis** NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.3 · Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstica: a todo cirrótico con ascitis de reciente inicio, que se hospitaliza o descompensa (fiebre, dolor, encefalopatía, falla renal). Evacuadora: ascitis a tensión o refractaria.
- Técnica: paciente en decúbito, punción en fosa ilíaca izquierda (unión del tercio externo y medio de la línea ombligo–espina ilíaca anterosuperior), asepsia, aguja fina en técnica en Z; evitar cicatrices y vasos epigástricos.
- Estudio del líquido: recuento celular (PMN ≥250/mm³ = PBE), albúmina para GASA (≥1,1 g/dL = hipertensión portal), proteínas, cultivo en frascos de hemocultivo, citología si se sospecha cáncer.
- Evacuadora >5 L: reponer albúmina ~8 g por litro extraído para evitar disfunción circulatoria; siempre hacer primero la diagnóstica para descartar PBE.
- La coagulopatía del cirrótico no la contraindica de rutina; evitar en CID o fibrinólisis franca. Complicaciones: filtración de líquido, hematoma de pared, perforación intestinal (rara).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 61 años con cirrosis y ascitis presenta dolor abdominal difuso, fiebre de 38 °C y leve confusión. Se realiza paracentesis diagnóstica. **¿Qué hallazgo del líquido ascítico confirma peritonitis bacteriana espontánea?**

A Recuento de polimorfonucleares de 250/mm3 o más

B Proteínas mayores de 2,5 g/dL

C Gradiente de albúmina suero-ascitis mayor de 1,1 g/dL

D Glucosa menor de 50 mg/dL con múltiples gérmenes en el Gram

E Recuento de glóbulos rojos mayor de 10.000/mm3

Respuesta A. La PBE se define por 250 o más polimorfonucleares por mm3 en el líquido ascítico, sin foco quirúrgico. Se trata con cefotaxima o ceftriaxona y albúmina. Un GASA mayor de 1,1 indica hipertensión portal, no infección. Glucosa baja con flora polimicrobiana sugiere peritonitis secundaria por perforación, que requiere TAC y cirugía.

07
GERIATRÍA

38 CÓDIGOS

63 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	17
Situaciones clínicas de urgencia	5
Conocimientos generales	12
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	4

Situaciones clínicas

17 códigos

▶ VER CLASE **1.07.1.001** **Caídas**

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.23 · Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Caídas: ~30% de los >65 años cae al año (50% en >80); consecuencias: fracturas (cadera, Colles, húmero), hematoma subdural, rabdomiólisis e hipotermia si permanece >1 h en el suelo, síndrome post-caída (miedo y dependencia).
- Evaluación: circunstancias, síncope o pérdida de conciencia, fármacos, ortostatismo (caída PAS ≥20 o PAD ≥10 mmHg a los 3 min de pie), visión, pies y calzado, cognición, marcha y equilibrio.
- Pruebas: Timed Up and Go (>12–14 s = riesgo; <10 s normal) y estación unipodal (<5 s anormal); ECG, glicemia, hemograma, electrolitos, función renal, vitamina D y B12 según el caso.
- Factores modificables: psicofármacos (benzodiacepinas, hipnóticos Z, antidepresivos, antipsicóticos), antihipertensivos e hipoglicemiantes, déficit visual, sarcopenia, riesgos del hogar (alfombras, poca luz, baño sin barras).
- Tratamiento multifactorial: ejercicio de fuerza, equilibrio y marcha (kinesiología, Vivifrail), desprescripción, corrección visual (catarata), adecuación del hogar, ayudas técnicas, vitamina D si déficit, tratar osteoporosis.
- Seguimiento: derivar a geriatría/kinesiología si caídas recurrentes, trastorno de marcha complejo o lesión; descartar fractura y TEC ante toda caída con dolor o anticoagulación.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 63

Hombre mayor consulta por miedo a caerse. Tuvo una caída hace 10 meses, sin lesiones. Al examen destaca atrofia leve de cuádriceps. Test Timed Up and Go de 14 segundos (VN menor de 14 s) y estación unipodal de 3 segundos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Ejercicios multicomponente
B Fortalecimiento de cuádriceps
C Caminata diaria
D Uso de bastón
E Observación clínica

Respuesta A. Caída previa, temor a caer, Timed Up and Go en el límite y estación unipodal menor de 5 segundos: riesgo aumentado de caídas. La intervención con mejor evidencia es el ejercicio multicomponente (fuerza, equilibrio y marcha), que reduce caídas y fracturas. Fortalecer solo el cuádriceps o caminar no entrena el equilibrio; el bastón no corrige la causa.

▶ VER CLASE **1.07.1.002** **Constipación y fecalomas**

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.2 · Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

QUÉ HAY QUE SABER

- Constipación (Roma IV): ≥2 de: <3 deposiciones/semana, esfuerzo, heces duras, sensación de evacuación incompleta u obstrucción, maniobras manuales, en >25% de las defecaciones.
- Causas en el adulto mayor: baja ingesta de fibra y líquidos, inmovilidad, fármacos (opioides, anticolinérgicos, calcio, hierro, calcioantagonistas), hipotiroidismo, hipercalcemia, Parkinson, depresión.
- Banderas rojas (derivar a colonoscopía): inicio reciente >50 años, rectorragia, anemia ferropénica, baja de peso, historia familiar de cáncer colorrectal.
- Fecaloma: dolor abdominal, distensión, diarrea paradójica por rebalse, retención urinaria o delirium; diagnóstico por tacto rectal. Tratamiento: desimpactación manual y enemas (fosfato o aceite mineral), luego laxante oral.
- Tratamiento escalonado: fibra 20–30 g/día + líquidos + actividad física → laxante osmótico (PEG 17 g/día o lactulosa 15–30 mL/día) → estimulante (bisacodilo, senósidos). Evitar aceite mineral oral en riesgo de aspiración.
- Seguimiento completo: hábito defecatorio regular (postprandial), revisar fármacos y laxante preventivo en usuarios de opioides.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 86 años, postrada y usuaria de opioides por artrosis, es traída por "diarrea" de 5 días: escurrimiento de deposiciones líquidas en pequeña cantidad, con distensión y dolor abdominal leve. No elimina deposiciones formadas hace 10 días. Al tacto rectal se palpa una masa de deposiciones duras en la ampolla. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Loperamida
B Coprocultivo y ciprofloxacino
C Colonoscopía urgente
D Desimpactación (extracción manual y enemas) seguida de laxantes osmóticos
E Ayuno y suero endovenoso

Respuesta D. Es un fecaloma con diarrea por rebalse: el líquido escurre alrededor de la impactación. Se trata con desimpactación (extracción digital y enemas) y luego laxantes osmóticos regulares, revisando fármacos constipantes como los opioides. La loperamida empeoraría el cuadro y los antibióticos no tienen indicación.

▶ VER CLASE 1.07.1.003 Demencia

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.14 · Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve
Neurología 10.15 · Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal

QUÉ HAY QUE SABER

- Demencia: deterioro cognitivo adquirido en ≥2 dominios (memoria, lenguaje, función ejecutiva, visuoespacial, conducta) con pérdida de funcionalidad. Alzheimer la más frecuente; luego vascular, Lewy y frontotemporal.
- Sospecha: olvidos progresivos, repetición de preguntas, desorientación, dificultad en actividades instrumentales (dinero, fármacos, teléfono); tamizaje con MMSE abreviado (EFAM), MoCA, Pfeiffer o test del reloj.
- Estudio de causas reversibles: TSH, B12, hemograma, electrolitos, calcio, glicemia, función renal y hepática, VDRL/VIH según riesgo, y neuroimagen (TAC o RM); descartar depresión y delirium.
- Pistas: Lewy (alucinaciones visuales, parkinsonismo, fluctuaciones, sensibilidad a neurolépticos), vascular (inicio brusco, escalonado, focalidad), frontotemporal (conducta y lenguaje en <65 años), hidrocefalia normotensiva (marcha, incontinencia, demencia).
- Manejo inicial: educación y apoyo al cuidador, estimulación cognitiva, control de factores vasculares, retiro de anticolinérgicos y benzodiacepinas; síntomas conductuales primero con medidas no farmacológicas. GES Alzheimer y otras demencias.
- Seguimiento: derivar a neurología/geriatría para confirmación y tratamiento específico (donepecilo, rivastigmina, galantamina; memantina en moderada-severa).

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 34

Un paciente de 65 años, es traído por su señora, dado que presenta dificultades en sus actividades de la vida diaria. Ella refiere que ha estado repetitivo con errores en el manejo del dinero, así como dificultad para realizar actividades que normalmente realizaba sin problemas. El niega estos síntomas. Al examen físico presenta frecuencia cardiaca 68 latidos por minutos, con presión arterial de 130/85 mmHg, sin alteraciones en el examen segmentario, ni signos de focalidad neurológica. **El diagnóstico más probable es:**

A Delirium
B Demencia vascular
C Depresión del adulto mayor
D Demencia tipo Alzheimer
E Demencia por cuerpos de Lewi

Respuesta D. Deterioro insidioso con pérdida de autonomía (errores con el dinero), anosognosia (él lo niega, consulta la esposa) y examen neurológico sin focalidad: demencia tipo Alzheimer.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 15

Una paciente de 86 años, viuda desde hace 2 años, consulta porque ha notado olvidos frecuentes de eventos recientes en el último año, que han aumentado en los últimos dos meses. Presenta temor de estar iniciando una enfermedad de Alzheimer. En la evaluación se muestra atenta, orientada, cooperadora. Además, puede invertir series y recuerda 2 de 3 palabras que se le comunican durante la entrevista. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Enfermedad de Alzheimer
B Duelo patológico
C Trastorno neurocognitivo menor
D Accidente vascular encefálico
E Delirium

Respuesta C. Queja cognitiva propia, déficit objetivo leve (recuerda 2 de 3 palabras), atención conservada y sin pérdida de autonomía: trastorno neurocognitivo menor (deterioro cognitivo leve).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 71 años con 10 meses de deterioro cognitivo fluctuante: hay días en que conversa normal y otros en que está somnoliento y confuso. Desde hace 6 meses ve niños y gatos en el living, sin angustiarse. Al examen: rigidez, bradicinesia y facies inexpresiva, sin temblor. Su familia pide tratamiento porque las alucinaciones son cada vez más frecuentes. **¿Cuál es el fármaco más adecuado?**

A Haloperidol 5 mg intramuscular

B Clorpromazina 25 mg en la noche

C Donepezilo

D Sertralina

E Esperar a completar un año de parkinsonismo antes de tratar

Respuesta C. Fluctuaciones, alucinaciones visuales tempranas y parkinsonismo espontáneo: demencia por cuerpos de Lewy. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa (donepezilo) mejoran fluctuaciones y alucinaciones. Los antipsicóticos típicos están contraindicados por hipersensibilidad grave. La sertralina se usa para la conducta en la demencia frontotemporal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 69

Un hombre de 78 años, acude a control, ya que su esposa refiere que, desde hace algunos meses ha presentado movimientos involuntarios mientras se está quedando dormido, presentando también problemas de memoria que han ido en aumento y se han asociado a algunas ideas paranoides. Además, ha estado más apático y desmotivado, aunque sus dificultades han tenido un curso fluctuante, pero con tendencia a empeorar. En el examen físico se aprecia colaborador y amable, con cierto grado de rigidez en extremidades superiores e inferiores, sin focalidad neurológica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Enfermedad de Parkinson

B Enfermedad de Alzheimer

C Hidrocefalia normotensiva

D Síndrome confusional agudo

E Demencia por cuerpos de Lewy

Respuesta B. Diagnóstico: Enfermedad de Alzheimer (opción B). Esta clase cubre la anemia ferropénica, la anemia más frecuente.

▶ VER CLASE 1.07.1.004 Depresión

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.1 · Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Depresión en el adulto mayor: frecuente y subdiagnosticada; predominan síntomas somáticos, ansiedad, quejas de memoria (pseudodemencia), anorexia, insomnio y aislamiento más que tristeza.
- Tamizaje con escala de Yesavage (GDS-15): ≥5 puntos sugiere depresión; confirmar con criterios DSM-5 (≥5 síntomas por ≥2 semanas, con ánimo deprimido o anhedonia).
- Descartar causas orgánicas y farmacológicas: hipotiroidismo, déficit de B12, demencia incipiente, Parkinson, ACV, cáncer, corticoides, betabloqueadores.
- Evaluar riesgo suicida siempre: los hombres mayores, viudos, con enfermedad crónica y aislados tienen la tasa de suicidio más alta.
- Tratamiento inicial: psicoeducación, activación conductual y red de apoyo; ISRS de elección (sertralina 25–50 mg/día o escitalopram 5–10 mg/día; citalopram máx. 20 mg/día por QT). Evitar tricíclicos y benzodiacepinas; vigilar hiponatremia y caídas.
- Seguimiento: derivar a especialista (psiquiatría/geriatría) si depresión severa, psicótica, riesgo suicida o falta de respuesta; GES depresión en ≥15 años.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 79 años con glaucoma de ángulo estrecho y constipación crónica presenta ánimo bajo, anhedonia, insomnio y baja de peso de 2 meses. Escala de Yesavage de 11 puntos. Sin ideación suicida ni síntomas psicóticos. **¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?**

A Amitriptilina

B Litio

C Clonazepam

D Imipramina

E Sertralina

Respuesta E. En el adulto mayor con depresión, los ISRS como sertralina o escitalopram son de primera línea por su buena tolerancia. Los tricíclicos (amitriptilina, imipramina) producen efectos anticolinérgicos, hipotensión y arritmias, y empeoran el glaucoma de ángulo estrecho y la constipación. Las benzodiacepinas no tratan la depresión y aumentan caídas y confusión.

▶ VER CLASE 1.07.1.005 Diabetes mellitus tipo 2

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 1.4 · Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico igual que en adultos: glicemia en ayunas ≥126 mg/dL ×2, PTGO a las 2 h ≥200 mg/dL, glicemia ≥200 con síntomas o HbA1c ≥6,5%; en el anciano los síntomas son atípicos (delirium, caídas, incontinencia, deshidratación).

- Metas individualizadas de HbA1c: <7–7,5% en sanos con buena funcionalidad; <8% con comorbilidad o deterioro cognitivo leve; <8,5% en frágiles o expectativa de vida limitada. Prioridad: evitar hipoglicemias.
- Primera línea: metformina (ajustar si VFG 30–45; suspender si <30), iSGLT2 si IC o ERC, iDPP-4 (linagliptina) por bajo riesgo de hipoglicemia; insulina basal (NPH o glargina) si es necesario.
- Evitar glibenclamida (Beers: hipoglicemia prolongada); si HbA1c baja o hipoglicemias en usuario de sulfonilurea o insulina, desintensificar.
- Control integral: PA, estatina según riesgo, pie diabético, fondo de ojo anual, RAC y VFG, vacunas; valorar cognición y funcionalidad.
- Seguimiento completo en APS (Programa de Salud Cardiovascular, GES DM2): controles periódicos, HbA1c cada 3–6 meses, educación al paciente y cuidador.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 84 años con DM2 de 20 años de evolución, demencia moderada, dependencia para actividades básicas y caídas frecuentes. Usa metformina y glibenclamida. Su HbA1c es 6,4% y su cuidadora refiere episodios matinales de sudoración y confusión. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener el tratamiento, ya que la HbA1c está en meta

B Suspender la glibenclamida y aceptar una meta de HbA1c cercana a 8%

C Agregar insulina NPH nocturna

D Aumentar la glibenclamida para lograr una HbA1c menor de 6%

E Reemplazar la metformina por glibenclamida en dosis máxima

Respuesta B. En el adulto mayor frágil, con demencia y dependencia, la meta de HbA1c se relaja a cerca de 8% para evitar hipoglicemias, que causan caídas, arritmias y deterioro cognitivo. Sus síntomas sugieren hipoglicemias por glibenclamida, una sulfonilurea de acción prolongada que debe suspenderse. Una HbA1c de 6,4% aquí refleja sobretratamiento.

▶ VER CLASE 1.07.1.006 Enfermedad cerebro-vascular

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.1 · Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ACV ante déficit neurológico focal súbito: asimetría facial, debilidad de un brazo, alteración del lenguaje (BE-FAST), hemianopsia, ataxia. En ancianos puede presentarse con confusión o caída.
- Activar código ACV y trasladar a centro con TAC y trombolisis: registrar hora de inicio (última vez visto sano); hemoglucotest para descartar hipoglicemia.
- TAC de cerebro sin contraste urgente para descartar hemorragia; trombolisis EV con alteplase o tenecteplase hasta 4,5 h; trombectomía mecánica en oclusión de gran vaso (hasta 24 h en casos seleccionados). La edad no es contraindicación.
- Manejo inicial: no bajar la PA salvo >220/120 (o >185/110 si se trombolizará), evitar hipotensión, SatO2 >94%, normoglicemia, régimen cero hasta evaluar deglución, cabecera a 30°.
- AIT: score ABCD2 para estratificar; iniciar antiagregación y estudio precoz (<24–48 h). Prevención secundaria: antiagregante o anticoagulante si FA, estatina, control de PA y DM.
- Seguimiento: derivar a neurología (GES ACV isquémico en ≥15 años) y rehabilitación precoz.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 84 años, autovalente e hipertensa, presenta hemiparesia derecha y afasia de inicio hace 90 minutos. PA 175/95 mmHg, glicemia 130 mg/dL. La TAC de cerebro sin contraste no muestra hemorragia ni hipodensidad extensa. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A No trombolizar por ser mayor de 80 años

B Trombolisis endovenosa, evaluando además trombectomía si hay oclusión de gran vaso

C Aspirina 300 mg y observar

D Bajar la presión a menos de 120/80 mmHg antes de decidir

E Heparina endovenosa en infusión

Respuesta B. La edad avanzada no contraindica la trombolisis: una paciente autovalente con ACV isquémico dentro de 4,5 horas y sin hemorragia en la TAC se beneficia de trombolisis endovenosa, y de trombectomía si hay oclusión proximal. Basta una PA bajo 185/110. La aspirina se inicia 24 horas después y la heparina no está indicada.

▶ VER CLASE 1.07.1.007 Escaras o úlceras por presión

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.22 · Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Úlceras por presión: daño de piel y tejidos sobre prominencias óseas (sacro, talones, trocánteres, isquion) por presión, cizalla y humedad; factores: inmovilidad, desnutrición, incontinencia, deterioro cognitivo.
- Clasificación: grado I eritema que no blanquea con piel íntegra; II pérdida parcial (flictena o úlcera superficial); III pérdida total de piel con tejido subcutáneo visible; IV exposición de músculo, tendón o hueso.
- Evaluar riesgo con escala de Braden (≤16 = riesgo; ≤12 alto riesgo) o Norton al ingreso y periódicamente.
- Prevención y manejo inicial: cambios de posición cada 2 h, colchón antiescaras, protección de talones, manejo de humedad e incontinencia, nutrición con proteínas 1,25–1,5 g/kg/día.

- Curación: limpieza con suero fisiológico, desbridamiento del tejido necrótico, apósitos que mantengan ambiente húmedo; no masajear prominencias. Infección: celulitis u osteomielitis requieren antibiótico sistémico.
- Seguimiento completo: registro semanal del tamaño y aspecto, curaciones por enfermería en APS/domicilio; derivar a cirugía si grado IV extenso u osteomielitis.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 82

Un paciente de 86 años, con antecedente de un accidente vascular encefálico hace un año, secuelado con un síndrome de inmovilidad y marcada dependencia, presenta una lesión en la zona sacra. Al examen físico se observa eritema en la zona sacra, sin solución de continuidad de la piel. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Aseo con hidrogel
B Colchón antiescaras
C Antibióticos
D Resolución quirúrgica
E Cambios de posición frecuentes

Respuesta E. Eritema sacro sin pérdida de continuidad de la piel es una úlcera por presión grado I. Lo fundamental es aliviar la presión con cambios de posición cada 2 horas, además de proteger e hidratar la piel y asegurar una nutrición adecuada. El colchón antiescaras complementa pero no reemplaza los cambios de posición; antibióticos y cirugía no corresponden.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 162

Un paciente de 78 años, postrado, presenta una lesión en la zona sacra, de 12 cm de diámetro, que afecta la piel y dermis y que en una zona deja entrever el músculo. Tiene necrosis en el borde y mal olor. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A Antibióticos tópicos
B Debridamiento químico
C Curaciones con suero fisiológico
D Colgajo
E Cámara hiperbárica

Respuesta B. Tiene una escara sacra grado l!l, por lo que, además de los cambios de posición, se debe realizar el debridamiento químico para eliminar el área necrótica y de mal olor y facilitar la curación. No se ven signos de celulitis, como para indicar antibióticos.

▶ VER CLASE 1.07.1.008 **Fragilidad** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.22 · Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Fragilidad: estado de vulnerabilidad por pérdida de reserva de múltiples sistemas; ante estresores menores sufre caídas, discapacidad, hospitalización y muerte. Es dinámica y reversible.
- Fenotipo de Fried (5 criterios): baja de peso involuntaria (≥4,5 kg o ≥5% en un año), agotamiento, prensión débil (<27 kg hombres, <16 kg mujeres), marcha lenta (<0,8 m/s) y baja actividad física. 3 o más = frágil; 1–2 = prefrágil.
- Sarcopenia (EWGSOP2): fuerza baja = sarcopenia probable (basta para tratar); se confirma con masa baja (DEXA o bioimpedancia) y es severa si además el rendimiento es bajo (marcha <0,8 m/s, TUG ≥20 s).
- Evaluar con Valoración Geriátrica Integral: funcional (Barthel, Lawton), cognitiva (Pfeiffer, MMSE), afectiva (Yesavage), nutricional (MNA) y social (Gijón); descartar causas orgánicas de baja de peso.
- Tratamiento: ejercicio multicomponente (fuerza contra resistencia, equilibrio, marcha) 3–5 días/semana; proteínas 1,2–1,5 g/kg/día; vitamina D 800–2000 UI/día si está baja; desprescribir sedantes y anticolinérgicos.
- Seguimiento completo: EMPAM anual en APS (EFAM-Chile) y programa Más Adultos Mayores Autovalentes.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 143

Hombre de 78 años con pérdida de masa muscular, fuerza de prensión <16 kg y velocidad de marcha 0.7 m/s. **¿Cuál es el diagnóstico y la intervención más eficaz?**

A Sarcopenia: ejercicio de resistencia progresivo + aporte proteico adecuado (1.2-1.5 g/kg/día)
B Desnutrición: solo suplementos nutricionales orales
C Depresión en adulto mayor: antidepresivos
D Osteoporosis: bifosfonatos
E Hipotiroidismo: levotiroxina

Respuesta A. Masa baja + fuerza baja + marcha < 0,8 m/s: sarcopenia (severa según EWGSOP2). La intervención más eficaz es el ejercicio de resistencia progresivo con aporte proteico de 1,2–1,5 g/kg/día; no hay fármaco de primera línea.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 78 años, autovalente, en control en APS. En el último año bajó de 58 a 52 kg sin dieta, camina más lento y ya no sale a comprar porque "se cansa enseguida". Dinamometría: 13 kg en la mano dominante. Recorre 4 metros en 7,2 s (0,55 m/s). Pfeiffer: 1 error. Barthel 95/100, Lawton 6/8. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?**

A Prefragilidad; control anual en EMPAM

B Fragilidad; ejercicio multicomponente y aporte proteico de 1,2–1,5 g/kg/día

C Demencia leve; derivar a neurología

D Fragilidad; solicitar DEXA de cuerpo entero antes de iniciar tratamiento

E Envejecimiento normal; no requiere intervención

Respuesta B. Cumple 4 criterios de Fried (baja de peso > 10 %, agotamiento, prensión < 16 kg, marcha < 0,8 m/s): fragilidad. La prensión baja define además sarcopenia probable, que basta para tratar. Conducta: ejercicio multicomponente (Vivifrail), proteínas 1,2–1,5 g/kg/día, medir vitamina D y descartar causas orgánicas de la baja de peso.

▶ VER CLASE 1.07.1.009 Hipertensión arterial

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.25 · Cardiovascular en el Adulto Mayor: Hipertensión Arterial y Evento Coronario

QUÉ HAY QUE SABER

- HTA en el adulto mayor: predomina la HTA sistólica aislada por rigidez arterial; confirmar con perfil de PA y considerar MAPA (delantal blanco frecuente). Medir siempre PA de pie por hipotensión ortostática.
- Metas: PAS <140 mmHg en general en ≥65 años autovalentes (130–139 si tolera); <150 mmHg en ≥80 años o frágiles, evitando PAS <120–130 y síntomas de hipoperfusión.
- Iniciar con dosis bajas y titular lentamente: calcioantagonistas DHP (amlodipino 2,5–5 mg), IECA/ARA-II o tiazidas en dosis bajas (vigilar hiponatremia e hipokalemia).
- Evitar alfabloqueadores (doxazosina) como primera línea, clonidina y metildopa (Beers: hipotensión ortostática y sedación); betabloqueador solo si indicación específica (cardiopatía coronaria, IC, FA).
- Estilo de vida: reducir sal a <5 g/día, actividad física adaptada, bajar de peso si obesidad; evaluar adherencia, polifarmacia y cognición.
- Seguimiento completo en APS (Programa de Salud Cardiovascular, GES HTA): controles periódicos con PA sentado y de pie, función renal y electrolitos tras ajustes.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 82 años, autovalente, sin diabetes ni enfermedad renal, presenta en el perfil de presión arterial promedios de 168/78 mmHg. Está asintomático y no tiene hipotensión ortostática. **¿Cuál es la afirmación más adecuada?**

A Es una hipertensión sistólica aislada fisiológica de la edad y no requiere tratamiento

B Debe iniciarse atenolol como primera línea

C Corresponde tratar con fármacos, ya que reduce ACV e insuficiencia cardíaca aun en mayores de 80 años

D La meta es una PA sistólica menor de 110 mmHg

E Debe descartarse primero una causa secundaria con angiografía renal

Respuesta C. La hipertensión sistólica aislada es la forma más frecuente en el adulto mayor por rigidez arterial y no es benigna. El estudio HYVET mostró que tratarla en mayores de 80 años reduce ACV, insuficiencia cardíaca y mortalidad. Se inicia con dosis bajas de tiazida, calcioantagonista o IECA/ARA II, evitando la hipotensión ortostática.

▶ VER CLASE 1.07.1.010 Hipotensión postural

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.23 · Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipotensión ortostática: caída de PAS ≥20 mmHg o PAD ≥10 mmHg dentro de 3 min de ponerse de pie (medir tras 5 min en decúbito); síntomas: mareo, visión borrosa, debilidad, caídas, síncope.
- Causas: fármacos (diuréticos, alfabloqueadores, nitratos, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, levodopa, antihipertensivos en exceso), hipovolemia, disautonomía (Parkinson, DM, amiloidosis), reposo prolongado.
- Estudio: electrolitos, glicemia, hemograma, función renal, ECG; si aumento de FC <15 lpm sugiere disautonomía neurogénica.
- Medidas no farmacológicas: revisar y ajustar fármacos, hidratación 1,5–2 L/día, levantarse en etapas, cabecera elevada 10–20°, medias de compresión, contramaniobras (cruzar piernas, contraer músculos), comidas pequeñas.
- Fármacos si persisten síntomas: fludrocortisona 0,1 mg/día (vigilar hipokalemia, edema, HTA supina) o midodrina 2,5–10 mg c/8 h (no al acostarse).
- Seguimiento completo: medir PA de pie en cada control, prevenir caídas y vigilar HTA en decúbito.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 76 años, usuario de doxazosina por hiperplasia prostática, consulta por mareos al ponerse de pie y una caída reciente. Se mide la presión arterial en decúbito y luego de 3 minutos de pie. **¿Cuál de los siguientes resultados confirma hipotensión ortostática?**

A Caída de la PA sistólica de 10 mmHg con aumento de la FC de 5/min

B Aumento de la PA sistólica de 20 mmHg

C Caída de la PA diastólica de 5 mmHg

D Caída de la PA sistólica de 25 mmHg

E Aumento de la FC de 30/min sin cambios en la PA

Respuesta D. La hipotensión ortostática se define como una caída de la PA sistólica de al menos 20 mmHg o de la diastólica de al menos 10 mmHg dentro de 3 minutos de bipedestación. Es causa frecuente de caídas, y los alfabloqueadores como la doxazosina son un gatillante clásico. Un alza aislada de FC sin hipotensión sugiere taquicardia postural.

▶ VER CLASE 1.07.1.011 Hipotermia

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.5 · Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipotermia: temperatura central <35 °C; leve 32–35 °C (escalofríos, taquicardia, confusión), moderada 28–32 °C (cesan escalofríos, bradicardia, estupor), severa <28 °C (coma, arritmias, FV, asistolia).
- Adultos mayores en riesgo: menor termogénesis y percepción del frío, inmovilidad tras caída, hipotiroidismo, sepsis, hipoglicemia, fármacos (sedantes, antipsicóticos), alcohol y pobreza energética.
- Medir con termómetro de baja lectura (rectal o esofágica). ECG: bradicardia, QT largo, onda J de Osborn, FA.
- Tratamiento: retirar ropa húmeda, manipulación cuidadosa (riesgo de FV), recalentamiento pasivo (mantas) en leve; activo externo (mantas térmicas) e interno (fluidos EV tibios a 40–42 °C, O2 humidificado caliente) en moderada-severa; ECMO en paro.
- Buscar y tratar causa: hipoglicemia, sepsis, hipotiroidismo, TEC; en paro por hipotermia, RCP prolongada ('nadie está muerto hasta que está caliente y muerto'), con desfibrilación y adrenalina restringidas si <30 °C.
- Seguimiento completo: prevención con calefacción adecuada, abrigo, alimentación y teleasistencia en ancianos que viven solos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 88 años que vive sola es encontrada en el suelo de su casa en invierno, tras una caída nocturna. Está somnolienta, con piel fría, temperatura rectal de 30 °C, FC 44/min y PA 95/60 mmHg. El ECG muestra bradicardia sinusal con ondas J de Osborn. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Recalentamiento solo con frazadas a temperatura ambiente

B Atropina y marcapaso transcutáneo inmediato

C Iniciar compresiones torácicas

D Baño de agua caliente a 45 °C

E Recalentamiento activo externo y con fluidos endovenosos tibios, con monitorización y manipulación cuidadosa

Respuesta E. Una temperatura de 30 °C es hipotermia moderada (28-32 °C), con bradicardia y ondas de Osborn típicas. Requiere recalentamiento activo externo con mantas térmicas y fluidos tibios, con monitor por riesgo de fibrilación ventricular ante una manipulación brusca. La bradicardia es fisiológica y no responde a atropina; con pulso presente no se hacen compresiones.

▶ VER CLASE 1.07.1.012 Incontinencia urinaria

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.24 · Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor
Urología 13.4 · Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica

QUÉ HAY QUE SABER

- Primero descartar causas transitorias (DIAPPERS): delirium, infección urinaria, atrofia vaginal, psicológicas, fármacos (diuréticos, anticolinérgicos, sedantes), exceso de diuresis (hiperglicemia, IC), restricción de movilidad y fecaloma (stool).
- Tipos: urgencia (deseo súbito, hiperactividad del detrusor), esfuerzo (pérdida al toser o reír), rebalse (goteo continuo, chorro débil, residuo postmiccional >150–200 mL) y funcional (no alcanza el baño por movilidad o cognición).
- Estudio inicial: diario miccional de 3 días, examen físico con tacto rectal y examen ginecológico, orina completa, urocultivo, glicemia y residuo postmiccional por ecografía.
- Tratamiento inicial: bajar de peso, evitar cafeína, té y alcohol, micciones programadas cada 2–3 h, ejercicios de Kegel; urgencia: oxibutinina 2,5–5 mg c/8–12 h o mirabegrón 25–50 mg/día (preferir mirabegrón si hay deterioro cognitivo).
- Esfuerzo: Kegel y estrógeno tópico si atrofia, cirugía (TVT/TOT) si falla. Rebalse: anticolinérgicos contraindicados; tratar la obstrucción (tamsulosina) o cateterismo intermitente limpio.
- Seguimiento: derivar a urología/ginecología si rebalse, hematuria, prolapso, fracaso del tratamiento o indicación quirúrgica.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 131

Mujer de 85 años tiene el diagnóstico de incontinencia urinaria de urgencia. Su examen ginecológico es normal, y trae un examen de orina, que resulta normal. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el mas indicado para el manejo de esta paciente? **¿Cuál de los siguientes fármacos es el más indicado para el manejo de esta paciente?**

A Amitriptilina
B Imipramina
C Oxibutinina
D Tolterodina
E Trazodona

Respuesta D. Los anticolinérgicos son de elección en la urgencia. Los tricíclicos están contraindicados en el adulto mayor. Entre oxibutinina y tolterodina, la tolterodina da menos efectos adversos, como boca seca.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 73 años, autovalente, consulta por 8 meses de pérdidas de orina precedidas de un deseo súbito e imperioso de orinar, que no alcanza a contener; orina cada 1 a 2 horas en pequeña cantidad y se levanta 3 veces en la noche. No pierde orina al toser. Examen ginecológico sin prolapso significativo, orina completa y urocultivo normales, residuo posmiccional de 40 mL. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A Oxibutinina oral
B Sonda Foley permanente
C Entrenamiento vesical con micción programada, ejercicios de piso pélvico y manejo de líquidos y cafeína
D Cirugía con cinta suburetral
E Uso de pañal como única medida

Respuesta C. Urgencia, frecuencia y nicturia con orina normal y residuo bajo: incontinencia de urgencia por vejiga hiperactiva. El tratamiento inicial es conductual: entrenamiento vesical, micción programada, ejercicios de piso pélvico y reducir cafeína y líquidos nocturnos. Si no basta, se prefiere mirabegrón, ya que la oxibutinina es anticolinérgica (Beers). La cinta es para incontinencia de esfuerzo.

▶ VER CLASE 1.07.1.013 Inmovilidad

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.22 · Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Inmovilidad: disminución de la capacidad para desplazarse o cambiar de posición que compromete la autonomía; causas: dolor osteoarticular, debilidad, ACV, Parkinson, demencia, miedo a caer, hospitalización y fármacos.
- Consecuencias rápidas: pérdida de 1–5% de fuerza muscular por día de reposo, úlceras por presión, TVP/TEP, neumonía aspirativa, constipación, incontinencia, delirium, hipotensión ortostática y contracturas.
- Evaluar: causa y duración, funcionalidad (Barthel), escala de Braden, estado nutricional, dolor, cognición y entorno social.
- Tratamiento: tratar la causa, movilización precoz progresiva (sentarse, bipedestación, marcha asistida), kinesiología, analgesia adecuada, ayudas técnicas (bastón, andador, silla de ruedas).
- Prevenir complicaciones: cambios de posición c/2 h, colchón antiescaras, tromboprofilaxis con HBPM si inmovilidad aguda de riesgo, hidratación, manejo intestinal y vesical.
- Seguimiento completo: programa de atención domiciliaria para personas con dependencia severa y apoyo al cuidador.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 81 años, autovalente, se hospitaliza por neumonía. Al tercer día está estable y afebril, pero permanece todo el día en cama, con sonda Foley instalada "por comodidad". **¿Cuál es la medida más eficaz para prevenir el síndrome de inmovilidad?**

A Movilización precoz, con sedestación en sillón y marcha asistida diaria, retirando la sonda innecesaria
B Reposo absoluto hasta el alta para evitar caídas
C Colchón antiescaras como única medida
D Suplemento de vitamina D en dosis altas
E Contención física nocturna

Respuesta A. La inmovilidad del adulto mayor hospitalizado produce pérdida rápida de fuerza muscular, úlceras por presión, trombosis, delirium y deterioro funcional. Lo más eficaz es la movilización precoz con sedestación y marcha asistida, y retirar dispositivos innecesarios como sondas, que atan al paciente a la cama. Las contenciones y el reposo prolongado agravan la inmovilidad.

▶ VER CLASE 1.07.1.014 Malnutrición

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.22 · Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Malnutrición en el adulto mayor: pérdida de peso involuntaria >5% en 6–12 meses, IMC <23 en mayores, albúmina baja (marcador también inflamatorio), disminución de masa muscular.

- Tamizaje con MNA (Mini Nutritional Assessment): <17 desnutrición, 17–23,5 riesgo; también circunferencia de pantorrilla <31 cm.
- Causas (las 'D'): dentición, disgeusia, disfagia, diarrea, depresión, demencia, disfunción (dependencia), drogas/fármacos (digoxina, ISRS, metformina), enfermedad crónica, cáncer, pobreza y aislamiento.
- Estudio: hemograma, albúmina, función renal y hepática, TSH, glicemia, B12 y folato; descartar neoplasia según clínica.
- Tratamiento: dieta enriquecida y fraccionada, aporte 30–35 kcal/kg/día y proteínas 1,0–1,5 g/kg/día, suplementos orales (PACAM en Chile), manejo de disfagia (modificar texturas), salud bucal y ejercicio de fuerza.
- Seguimiento: derivar a nutricionista/geriatría si desnutrición establecida, disfagia o pérdida de peso no explicada; evitar restricciones dietarias innecesarias.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 80 años que vive sola, viuda reciente, es evaluada en el examen de medicina preventiva del adulto mayor. Refiere menor apetito y ha bajado 4 kg en 3 meses. **¿Cuál es el instrumento validado más adecuado para tamizar malnutrición en esta paciente?**

A Índice de Barthel

B Escala de Tinetti

C Escala de Yesavage

D Test de Pfeiffer

E Mini Nutritional Assessment (MNA)

Respuesta E. El Mini Nutritional Assessment es el instrumento validado para tamizar malnutrición o riesgo nutricional en adultos mayores: considera ingesta, pérdida de peso, movilidad, estrés, estado neuropsicológico e IMC. Barthel mide funcionalidad, Yesavage depresión, Pfeiffer cognición y Tinetti marcha y equilibrio. Su baja de peso obliga además a descartar depresión y causas orgánicas.

▶ VER CLASE 1.07.1.015 Osteoporosis

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.18 · Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Osteoporosis: T-score ≤−2,5 en DEXA de columna lumbar o cadera, o fractura por fragilidad (cadera o vertebral) independiente del T-score. Osteopenia: T-score entre −1 y −2,5.
- Tamizaje con DEXA a mujeres ≥65 años y hombres ≥70, o antes con factores de riesgo (corticoides ≥3 meses, menopausia precoz, bajo peso, fractura previa, tabaco); FRAX estima riesgo de fractura a 10 años.
- Descartar causas secundarias: calcio, fósforo, fosfatasas alcalinas, 25-OH vitamina D, creatinina, TSH, PTH; electroforesis de proteínas si sospecha de mieloma.
- Medidas generales: calcio 1000–1200 mg/día (dieta + suplemento), vitamina D 800–2000 UI/día, ejercicio con carga, prevenir caídas, dejar tabaco y alcohol.
- Fármaco de primera línea: alendronato 70 mg/semana en ayunas con agua, de pie 30 min (contraindicado si VFG <35 o trastorno esofágico); alternativas: ácido zoledrónico 5 mg EV anual, denosumab 60 mg SC c/6 meses (no suspender sin transición).
- Seguimiento completo: DEXA cada 2 años, adherencia, reevaluar a los 5 años de bisfosfonato oral (pausa terapéutica si bajo riesgo); vigilar osteonecrosis mandibular y fractura atípica de fémur.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 74 años consulta por dolor dorsal tras levantar una bolsa de compras. La radiografía muestra una fractura por aplastamiento de la vértebra T12. No tiene antecedente de cáncer y la calcemia es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de su osteoporosis?**

A Esperar el resultado de la densitometría para decidir si tratar

B Solo calcio y vitamina D, porque el bisfosfonato es para T-score menor de -3

C Iniciar bisfosfonato (alendronato) más calcio y vitamina D

D Iniciar terapia de reemplazo hormonal

E Reposo en cama por 6 semanas

Respuesta C. Una fractura vertebral por fragilidad establece el diagnóstico clínico de osteoporosis, independiente del T-score, y obliga a tratar con bisfosfonato (alendronato), calcio y vitamina D, además de prevenir caídas. La densitometría sirve como basal, pero no condiciona el inicio. La terapia hormonal no se usa con este fin a esta edad y el reposo prolongado acelera la pérdida ósea.

▶ VER CLASE 1.07.1.016 Temblor

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.13 · Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Temblor esencial: postural y de acción, bilateral y simétrico en manos, puede afectar cabeza y voz; mejora con alcohol, historia familiar frecuente; sin otros signos neurológicos.
- Temblor parkinsoniano: de reposo, asimétrico, 'cuenta monedas', disminuye con el movimiento; acompañado de bradicinesia, rigidez e inestabilidad postural. GES Parkinson.
- Temblor fisiológico exacerbado: fino, por ansiedad, cafeína, hipertiroidismo, hipoglicemia, abstinencia alcohólica y fármacos (salbutamol, litio, valproato, levotiroxina, ISRS).
- Parkinsonismo inducido por fármacos (metoclopramida, haloperidol, flunarizina, cinarizina): bilateral y simétrico; tratamiento es suspender el fármaco.

- Manejo inicial: solicitar TSH y revisar fármacos; temblor esencial con impacto funcional: propranolol 20–80 mg/día (evitar en asma, bradicardia) o primidona 25–250 mg/día en la noche.
- Seguimiento: no requiere seguimiento especializado el temblor esencial controlado; derivar a neurología si sospecha de Parkinson, temblor atípico o refractario.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 76 años consulta por temblor de ambas manos de 2 meses, que aparece al sostener la taza y al escribir y desaparece en reposo. Refiere además palpitaciones, insomnio y baja de 3 kg. Usa levotiroxina 150 µg/día, cuya dosis se aumentó hace 3 meses. Examen: temblor postural fino y simétrico, sin rigidez ni bradicinesia, FC 104 lpm. TSH 0,04 mUI/L (VN 0,4–4,5). **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar propranolol de forma indefinida por temblor esencial

B Iniciar levodopa/carbidopa

C Reducir la dosis de levotiroxina y controlar la TSH en 6 a 8 semanas

D Solicitar RM de encéfalo

E Iniciar clonazepam nocturno

Respuesta C. Ante un temblor postural de inicio reciente en una persona mayor, primero se buscan causas secundarias: fármacos (levotiroxina, salbutamol, litio, valproato), hipertiroidismo, cafeína o abstinencia. Aquí la TSH suprimida tras subir la levotiroxina explica un temblor fisiológico exagerado: se ajusta la dosis. No es Parkinson (sin reposo ni bradicinesia) y no corresponde rotularlo como esencial.

▶ VER CLASE 1.07.1.017 **Trastornos de la marcha** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.23 · Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastornos de la marcha: factor de riesgo mayor de caídas y dependencia; afecta a ~30–40% de los mayores de 70 años.
- Patrones: parkinsoniana (pasos cortos, festinante, sin braceo, congelamiento), hidrocefalia normotensiva (marcha magnética + incontinencia + demencia), atáxica cerebelosa (base amplia), sensitiva (Romberg +, neuropatía, déficit B12), hemiparética (secuela de ACV), antiálgica (artrosis) y cautelosa (miedo a caer).
- Evaluación: velocidad de marcha (<0,8 m/s anormal), Timed Up and Go (>12–14 s riesgo), estación unipodal, Romberg, fuerza, sensibilidad, visión, pies y calzado; revisar fármacos sedantes.
- Estudio dirigido: B12, TSH, glicemia, neuroimagen si sospecha de hidrocefalia normotensiva, ACV o lesión estructural.
- Tratamiento: kinesiología con ejercicios de fuerza, equilibrio y marcha; ayuda técnica adecuada (bastón en mano contraria al lado afectado, andador); tratar causa (levodopa en Parkinson, B12, analgesia); desprescripción.
- Seguimiento: derivar a neurología, traumatología o geriatría según la causa (punción evacuadora/derivación en hidrocefalia normotensiva).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 76 años con 1 año de alteración progresiva de la marcha: pasos cortos, base amplia, como si los pies estuvieran pegados al suelo, con dificultad para iniciar la marcha y girar. En los últimos meses tiene urgencia e incontinencia urinaria y lentitud para pensar. Sin temblor de reposo; braceo conservado. TAC de encéfalo: ventriculomegalia desproporcionada respecto de los surcos corticales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar levodopa/carbidopa

B Solo kinesiterapia motora

C Iniciar donepezilo

D Punción lumbar evacuadora (tap test) y derivación a neurocirugía

E RM de columna lumbar por sospecha de canal estrecho

Respuesta D. Marcha magnética, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo (tríada de Hakim) con ventriculomegalia sin atrofia proporcional: hidrocefalia normotensiva, causa tratable de trastorno de la marcha y demencia. Se realiza punción lumbar evacuadora de 30 a 50 mL; si la marcha mejora, predice buena respuesta a la derivación ventrículo-peritoneal. La marcha es lo que mejor responde.

Situaciones clínicas de urgencia

5 códigos

▶ VER CLASE 1.07.2.001 **Abdomen agudo en adulto mayor** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 5.2 · Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular

QUÉ HAY QUE SABER

- En el adulto mayor el abdomen agudo es atípico: menos dolor, fiebre y signos peritoneales; puede presentarse como delirium, caídas o deterioro general; mayor mortalidad.
- Causas frecuentes: colecistitis y colangitis, obstrucción intestinal (bridas, hernias, cáncer de colon, vólvulo de sigmoides), diverticulitis, apendicitis perforada, úlcera perforada, isquemia mesentérica y AAA roto.
- Isquemia mesentérica aguda: dolor intenso desproporcionado al examen físico en paciente con FA o aterosclerosis, lactato elevado; angioTAC urgente.
- Descartar causas extraabdominales: IAM inferior (ECG y troponina), neumonía basal, cetoacidosis, retención urinaria y fecaloma.

- Estudio: hemograma, PCR, lipasa, perfil hepático, función renal, electrolitos, lactato, orina, ECG; TAC de abdomen con contraste como examen de elección (umbral bajo para solicitarla).
- Manejo inicial: régimen cero, hidratación EV, analgesia (no enmascara el diagnóstico), sonda nasogástrica si obstrucción, antibióticos si sepsis; seguimiento: derivar a cirugía precozmente.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 83 años con fibrilación auricular sin anticoagulación consulta por dolor abdominal intenso de 6 horas. Al examen el abdomen está blando, levemente sensible, sin signos peritoneales. Lactato 4,2 mmol/L, leucocitos 16.000/mm3. **¿Cuál es el examen más adecuado?**

A Angio-TAC de abdomen
B Radiografía simple de abdomen
C Ecografía abdominal
D Endoscopía digestiva alta
E Observación y control de exámenes en 24 horas

Respuesta A. En el adulto mayor, el abdomen agudo suele tener un examen engañosamente benigno. Dolor desproporcionado al examen, fibrilación auricular y lactato elevado sugieren isquemia mesentérica aguda embólica, cuyo examen de elección es la angio-TAC. Observar retrasa el diagnóstico de una patología de alta mortalidad, y la radiografía y la ecografía son poco sensibles.

▶ VER CLASE 1.07.2.002 Evento coronario en adulto mayor

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.25 · Cardiovascular en el Adulto Mayor: Hipertensión Arterial y Evento Coronario

QUÉ HAY QUE SABER

- Presentación atípica frecuente en ancianos, mujeres y diabéticos: disnea, fatiga, síncope, delirium, náuseas, dolor epigástrico o IC aguda sin dolor torácico típico.
- Ante la sospecha: ECG en <10 min y troponina ultrasensible seriada (0 y 1–3 h); interpretar troponina considerando ERC, IC y sepsis, que la elevan en forma crónica.
- IAM con SDST: reperfusión urgente (angioplastía primaria preferida en ancianos; trombolisis si no disponible en <120 min, con mayor riesgo hemorrágico: en ≥75 años tenecteplase a media dosis según protocolo y clopidogrel 75 mg sin carga).
- Tratamiento inicial: aspirina 250–500 mg, segundo antiagregante, anticoagulación ajustada a función renal y peso, estatina; nitratos con precaución por hipotensión. La edad sola no contraindica estrategias invasivas.
- Considerar fragilidad, cognición, comorbilidad y preferencias del paciente para decidir intensidad del tratamiento.
- Seguimiento completo: prevención secundaria (AAS, estatina, betabloqueador, IECA), rehabilitación cardíaca, revisión de polifarmacia, interacciones y riesgo de sangrado.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 86 años, diabética e hipertensa, es traída por disnea súbita, sudoración y confusión de 1 hora. No refiere dolor torácico. PA 100/60 mmHg, FC 105/min, SatO2 92%. **¿Cuál es el examen que debe realizarse primero?**

A Dímero D
B TAC de cerebro sin contraste
C Radiografía de tórax
D Electrocardiograma de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos
E Ecocardiograma transtorácico

Respuesta D. En adultos mayores, diabéticos y mujeres, el síndrome coronario agudo suele presentarse sin dolor torácico, con disnea, confusión, síncope o sudoración. Ante esta sospecha se realiza un ECG de 12 derivaciones en menos de 10 minutos, junto con troponinas, porque un supradesnivel del ST cambia la conducta de inmediato.

▶ VER CLASE 1.07.2.003 Fractura de cadera

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.23 · Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES
Traumatología 12.10 · Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: caída de su altura en adulto mayor, dolor inguinal, imposibilidad de ponerse de pie y extremidad acortada y en rotación externa. Puede ser dolor de cadera sin deformidad (fractura no desplazada).
- Confirmación: radiografía de pelvis AP y lateral de cadera; si es normal con alta sospecha, TAC o RM. Clasificar intracapsular (cuello femoral, Garden) o extracapsular (pertrocantérica).
- Manejo inicial: analgesia multimodal (paracetamol, opioides en dosis bajas, bloqueo de fascia ilíaca), hidratación, prevenir delirium y úlceras por presión, tromboprofilaxis, evaluar anticoagulantes.
- GES fractura de cadera en ≥65 años: cirugía dentro de las 48 horas; intracapsular desplazada → artroplastia (parcial si frágil, total si activo); extracapsular → osteosíntesis (clavo cefalomedular o DHS).
- Postoperatorio: HBPM (enoxaparina 40 mg/día) por 28–35 días, sedestación y marcha en 24–48 h, manejo ortogeriátrico; mortalidad al año 20–30%.

- Seguimiento: derivar a traumatología; luego prevención secundaria con tratamiento de osteoporosis (zoledrónico o denosumab), calcio/vitamina D y prevención de caídas.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 88 años, postrada hace tres años por secuelas de un accidente vascular, sufre una caída de la cama y presenta una fractura de cuello femoral desplazada. Tiene dolor intenso al movilizarla y está en riesgo de delirium. No camina desde hace tres años. **¿Cuál es la cirugía más adecuada?**

A Prótesis total de cadera cementada
B Tornillos canulados
C Cirugía de Girdlestone
D Tornillo dinámico de cadera
E Manejo conservador con reposo y analgesia

Respuesta C. En un paciente postrado crónico que ya no camina, la cirugía de salvataje es la de Girdlestone: se retira la cabeza femoral para eliminar el dolor y evitar complicaciones como el delirium, sin implantes costosos. La prótesis se reserva para quien camina. El tornillo dinámico es para fracturas intertrocantéricas, y el manejo conservador tiene alta mortalidad.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 82 años, hipertensa y con fibrilación auricular, en tratamiento con atenolol y apixabán. Tropieza con una alfombra y cae desde su propia altura sobre la región glútea derecha. No puede ponerse de pie. Extremidad inferior derecha acortada y en rotación externa marcada, dolor inguinal intenso, sin déficit neurovascular. Radiografía: fractura subcapital de cuello femoral desplazada (Garden IV). **¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección?**

A Osteosíntesis con tornillos canulados
B Clavo cefalomedular
C Artroplastia de cadera (hemiartroplastia o prótesis total)
D Tracción esquelética y reposo por 6 semanas
E Tornillo placa deslizante (DHS)

Respuesta C. Fractura intracapsular desplazada (Garden IV): los vasos retinaculares están rotos, con alto riesgo de necrosis avascular y fracaso de la osteosíntesis. Se indica artroplastia, dentro de 48 horas (GES), con analgesia multimodal, tromboprofilaxis con HBPM por 28–35 días y rehabilitación precoz. El clavo y el DHS son para fracturas extracapsulares.

▶ VER CLASE 1.07.2.004 **Agitación y agresividad** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.14 · Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

QUÉ HAY QUE SABER

- Agitación en el adulto mayor: primero descartar delirium (inicio agudo, fluctuante, inatención) y causas orgánicas: dolor, retención urinaria, fecaloma, infección, hipoxia, hipoglicemia, fármacos o abstinencia.
- En demencia, la agitación (síntomas conductuales y psicológicos) se gatilla por dolor, cambios de ambiente, sobreestimulación, necesidades no satisfechas o cuidador sobrepasado.
- Primera línea no farmacológica: ambiente tranquilo, orientación, lenguaje calmado, no confrontar, acompañamiento de familiar, rutina, luz natural de día, corregir déficit sensorial; evitar sujeción física.
- Fármacos solo si riesgo para sí o terceros: haloperidol 0,5–1 mg VO/IM (máx. 2–3 mg/día, controlar QTc) o quetiapina 12,5–25 mg (de elección en Parkinson o Lewy); risperidona 0,25–0,5 mg en demencia. Dosis mínima y por tiempo limitado.
- Evitar benzodiacepinas (empeoran confusión y caídas), salvo abstinencia alcohólica o de sedantes. Los antipsicóticos aumentan mortalidad y ACV en demencia.
- Seguimiento: derivar a geriatría/psiquiatría si agitación persistente, psicosis o necesidad de tratamiento prolongado.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 12

Mujer de 78 años con diagnóstico de Alzheimer moderado. Presenta agitación nocturna severa, intentos de golpear a cuidadores y deambulación sin propósito, que no cede con medidas no farmacológicas. **¿Cuál es el fármaco más apropiado?**

A Donepezilo
B Haloperidol en dosis alta
C Risperidona 0.5 mg nocturno
D Memantina
E Quetiapina 25 mg nocturno

Respuesta E. Síntomas conductuales graves que no ceden con medidas no farmacológicas: antipsicótico atípico en dosis mínima, preferentemente quetiapina 12,5–25 mg nocturna, por su menor perfil extrapiramidal. Advertencia: aumenta el riesgo de ACV y mortalidad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 128

Adulto mayor con enfermedad de Alzheimer presenta agitación nocturna e insomnio, y permanece tranquilo durante el día. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Risperidona 8-10 gotas en la noche
B Zolpidem 10 mg al acostarse
C Haloperidol 5 mg IM nocturno
D Clonazepam 0,5 mg oral en la noche
E Melatonina 3 mg al acostarse

Respuesta A. La agitación en la demencia se maneja primero con medidas no farmacológicas; si persiste, se usan antipsicóticos atípicos en dosis bajas, siendo la risperidona (unas 8-10 gotas de solución de 1 mg/mL) la de mejor evidencia. Benzodiacepinas y zolpidem aumentan caídas y confusión, el haloperidol intramuscular da efectos extrapiramidales y la melatonina carece de eficacia demostrada.

▶ VER CLASE 1.07.2.005 Síndrome confusional agudo / delirium

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.21 · Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente

QUÉ HAY QUE SABER

- Delirium: disfunción cerebral aguda y fluctuante; diagnóstico clínico con CAM: (1) inicio agudo y curso fluctuante + (2) inatención, más (3) pensamiento desorganizado o (4) alteración del nivel de conciencia.
- Subtipos: hipoactivo (~50%, el más frecuente, subdiagnosticado y de peor pronóstico), hiperactivo y mixto. Duplica la mortalidad y acelera el deterioro cognitivo.
- Siempre buscar la causa: infección (urinaria, neumonía), fármacos (anticolinérgicos, benzodiacepinas, opioides), alteraciones metabólicas (Na, Ca, glicemia, uremia), hipoxia, dolor, retención urinaria, fecaloma, IAM silente, ACV, abstinencia.
- Estudio: hemograma, electrolitos, glicemia, función renal y hepática, calcio, orina y urocultivo, Rx de tórax, ECG, saturación; neuroimagen si focalidad, TEC o anticoagulación.
- Tratamiento: corregir la causa + medidas no farmacológicas (reorientación, lentes y audífonos, sueño, movilización, hidratación, retirar sondas, familia presente); sujeción proscrita. Haloperidol 0,5–1 mg solo si agitación con riesgo; quetiapina en Parkinson/Lewy; benzodiacepinas solo en abstinencia (más tiamina).
- Seguimiento: derivar a especialista según causa; control cognitivo posterior, pues muchos tienen demencia subyacente o la desarrollan.

PREGUNTAS · 12

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 68

Un paciente de 80 años, autovalente, inicia cuadro de compromiso del estado general, tos y expectoración mucopurulenta, se realiza radiografía de tórax en donde se comprueba diagnóstico de neumonía basal derecha por lo que se hospitaliza para el tratamiento. Durante la hospitalización en la noche el paciente se agita, se saca sonda foley y vías venosas, durante la mañana está tranquilo. **El diagnóstico más probable es:**

A Síndrome confusional agudo
B Delirio
C Alzheimer
D Meningitis bacteriana
E Demencia frontotemporal

Respuesta A. Inicio agudo en contexto de una neumonía, agitación nocturna y lucidez en la mañana: curso fluctuante típico del síndrome confusional agudo (delirium). "Delirio" en Chile designa la pérdida del juicio de realidad de los cuadros psicóticos, no el delirium.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 139

Un paciente de 84 años presenta desgarro mucopurulento, desde hace 4 días, por lo que se hospitaliza y se inicia tratamiento antibiótico. Evoluciona con dificultades para reconocer a sus hijos y esposa, a quienes confunde con su mamá y hermanos ya fallecidos. Se molesta cuando lo contrarían e incluso llegó a agredir físicamente a uno de sus hijos. **El diagnóstico más probable es:**

A Enfermedad de Alzheimer
B Trastorno delirante
C Depresión psicótica
D Esquizofrenia
E Delírium

Respuesta E. Desorientación y compromiso de conciencia de inicio agudo, secundario a una infección bacteriana: delirium. Las alucinaciones y las ideas delirantes son frecuentes en el delirium; la esquizofrenia y el trastorno delirante son cuadros crónicos.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 79 años, autovalente, en su 2.º día postoperatorio de artroplastia de cadera. En la madrugada inicia bruscamente inquietud extrema, dice que "hay animales debajo de la cama", intenta retirarse la vía venosa y no reconoce a su hija. PA 145/85, FC 98, afebril, $SatO_2$ 95 %. No logra deletrear MUNDO al revés. Se palpa una masa hipogástrica dolorosa, mate a la percusión. Herida limpia. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Haloperidol 1 mg intramuscular

B Lorazepam 1 mg endovenoso

C Instalar sonda Foley descompresiva

D Sujeción mecánica de las cuatro extremidades

E Solicitar TAC de cerebro urgente

Respuesta C. Delirium hiperactivo (CAM positivo) gatillado por una retención aguda de orina, frecuente tras anestesia neuroaxial y opioides. La sonda Foley revierte la agitación en minutos, junto con medidas no farmacológicas. Medicar o contener sin drenar el globo vesical es mala práctica; las benzodiacepinas están contraindicadas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 172

Adulto mayor hospitalizado por infección, comienza con desorientación temporoespacial, inatención e ideas deliriosas. ¿Diagnóstico más probable?

A Demencia de inicio agudo

B Trastorno psicótico breve

C Delirium

D Encefalopatía hepática

E Trastorno disociativo agudo

Respuesta C. Diagnóstico: Delirium (opción C). Delirium. Esta clase cubre la púrpura de Schonlein-Henoch, también llamada vasculitis por IgA.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 8

Mujer de 81 años, hospitalizada por neumonía, presenta agitación psicomotora en las noches, agrediendo al personal hospitalario y no reconoce a sus familiares. En el día, por el contrario, está en buenas condiciones, tranquila y no recuerda lo sucedido. ¿Cuál es el diagnostico más probable?

A Esquizofrenia

B Accidente vascular encefálico

C Delirium

D Demencia

E Trastorno delirante

Respuesta C. Es un delirium clásico (alteración de la atención, compromiso de conciencia de inicio agudo, desorientación y agitación; suele tener un curso fluctuante y empeorar al atardecer y en la noche). También se llama síndrome confusional agudo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 138

Una paciente de 78 años, diabética e hipertensa, es hospitalizada por una pielonefritis aguda. Estaba en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida y metformina. Durante el día está tranquila, pero en la noche se agita y dice que la tienen secuestrada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Indicar benzodiacepinas en la noche

B Indicar haloperidol oral

C Agregar glibenclamida al tratamiento

D Disminuir la dosis de metformina

E Administrar suero fisiológico

Respuesta B. Es un delirium. Se trata, tratando la causa, pero sirve dar haldol en bajas dosis (también sirve la risperidona en bajas dosis, aunque no ha demostrado ser mejor que el Haldol). Para el manejo de la diabetes, está indicada la insulina, en este caso. Las BDZ están contraindicadas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 168

Paciente de 76 años, con antecedentes de HTA en tratamiento, es hospitalizado por neumonía requiriendo antibióticos endovenosos. Estando hospitalizado comienza con desorientación temporoespacial, inatención y pensamiento desorganizado, de curso fluctuante durante el día. El diagnóstico más probable es:

A Demencia senil

B Demencia frontotemporal

C Esquizofrenia

D Trastorno delirante crónico

E Delirium

Respuesta E. Diagnóstico: Delirium (opción E). Delirium de libro. Siempre preguntan varios delirium o síndrome confusional agudo. Esta clase cubre la púrpura de Schonlein-Henoch, también llamada vasculitis por IgA.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 119

Una paciente de 74 años hospitalizada, desde hace una semana, por una fractura de cadera. Ha presentado cambios en su conducta, ya que al inicio era amable y cooperadora, pero en el último tiempo se ha agitado y mostrado confusa, e incluso ha llegado a agredir a otros pacientes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Enfermedad de Alzheimer
B Trastorno delirante
C Esquizofrenia
D Demencia vascular
E Delírium

Respuesta E. Diagnóstico: Delírium (opción E). Es un síndrome confusional agudo o delirium clásico. Esta clase cubre la púrpura de Schonlein-Henoch, también llamada vasculitis por IgA.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 130

Una mujer de 75 años, sufre caída a nivel presentando fractura de cuello femoral, por lo que se realiza prótesis total de cadera. Luego de la cirugía comienza a hablar incoherencias, se agita, se vuelve agresiva y además presenta desorientación temporoespacial. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo de esta paciente?

A Risperidona v.o
B Haloperidol e.v
C Diazepam i.m
D Lorazepam e.v
E Midazolam e.v

Respuesta B. Tiene un delirium. Lo más importante es tratar la causa. La agitación, se puede tratar con haloperidol, intramuscular en la dosis más baja posible y luego, se mantiene con la mitad de la dosis, por vía oral. Idealmente no darlo ev, aunque el uptodate pone Haldol ev, como tratamiento de elección, ya que la dosis es muy bajita: 0,5 a 1 mg. La risperidona oral sirve mucho también, pero si está agitado, puede ser difícil de entregarlo. Es pregunta muy discutible, ya que ambos medicamentos han...

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 131

Una paciente de 75 años, con historia de enfermedad de Alzheimer de 3 años de evolución, con buena funcionalidad presenta un cuadro en que agrede a otras personas y se muestra muy angustiada. Al examen físico le cuesta nombrar algunos objetos, no puede decir los días de la semana de manera invertida y se muestra poco atenta. Además, refiere que su padre ya fallecido está presente en la sala. Se hospitaliza para estudio y manejo y, al inicio, se muestra cooperadora y amable, pero luego exige que la dejen ir e intenta escapar del hospital y agredir al personal de salud. ¿Cuál es el fármaco inicial para el manejo de esta paciente?

A Clorpromazina
B Diazepam
C Mirtazapina
D Alprazolam
E Haloperidol

Respuesta E. Tiene un delírium o síndrome confusional agudo clásico. Se trata con el manejo de la patología de base (ej. infecciones, infartos, etc.) y con antipsicóticos, de preferencia haloperidol en dosis bajas (0,5 mg IM) o bien, risperidona 0,5 a 1 mg VO.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 127

Adulta mayor con Parkinson hospitalizada por ITU, presenta desorientación e ideas deliriosas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado (además de tratar la ITU)?

A Haloperidol IM
B Lorazepam oral
C Risperidona a bajas dosis
D Quetiapina oral
E Contención física y ambiental

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Risperidona a bajas dosis (opción C). Risperidona a bajas dosis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 96

Un paciente de 84 años es traído a urgencia por familiares. Refieren que sus síntomas iniciaron hace 7 días, consistentes en tos con expectoración purulenta, sensación febril y disnea de esfuerzos. En las últimas noches se ha levantado algo agitado y anoche estuvo muy agitado, gritando que habían entrado extraterrestres en su casa y que lo querían matar. Al examen físico, tiene T°: 37,9°C, PA: 154/100, FC: 88x', FR: 25x', satura: 93% a FiO2 ambienta, tiene examen pulmonar con crepitaciones en la base derecha y examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos sin soplos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Accidente vascular encefálico
B Delirium
C Epilepsia del lóbulo temporal
D Demencia tipo Alzheimer
E Esquizofrenia paranoide

Respuesta C. Diagnóstico: Epilepsia del lóbulo temporal (opción C). Esta clase cubre la púrpura de Schonlein-Henoch, también llamada vasculitis por IgA.

Conocimientos generales

12 códigos

▶ VER CLASE 1.07.3.001 Alteración de la termoregulación

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.1 · Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)

QUÉ HAY QUE SABER

- Con la edad disminuyen la termogénesis (menos masa muscular y escalofríos), la vasoconstricción y vasodilatación cutánea, la sudoración y la percepción de sed y temperatura.
- Fiebre atenuada o ausente en infecciones graves: hasta un tercio de los ancianos con sepsis no presenta fiebre; considerar febril un alza ≥1,1–1,3 °C sobre la basal o T° oral ≥37,8 °C persistente. El delirium o la caída funcional pueden ser el único signo.
- Riesgo de hipotermia en invierno y tras caídas con permanencia en el suelo; agravan el hipotiroidismo, la desnutrición, el alcohol y sedantes/antipsicóticos.
- Riesgo de golpe de calor y deshidratación en olas de calor: diuréticos, anticolinérgicos, antipsicóticos y dependencia; síntomas de confusión, T° >40 °C y piel seca.
- Prevención: vivienda temperada (18–24 °C), ropa adecuada, hidratación programada (1,5–2 L/día) aunque no tenga sed, alerta a familiares en temperaturas extremas.
- Ante un adulto mayor con deterioro agudo sin fiebre, buscar activamente infección (orina, tórax, piel) y medir lactato si hay hipotensión.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 85 años es traído por confusión de 1 día. Temperatura axilar 37,1 °C, FR 24/min, PA 92/58 mmHg, FC 104/min. Orina turbia, con leucocituria y nitritos positivos. Lactato 3 mmol/L. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Sin fiebre se descarta una infección grave y debe buscarse otra causa de la confusión

B El adulto mayor puede no hacer fiebre por alteración de la termorregulación; corresponde manejarlo como sepsis de foco urinario

C Es una bacteriuria asintomática que no debe tratarse

D La confusión es esperable a esta edad y no requiere estudio

E Debe esperarse la curva febril antes de iniciar antibióticos

Respuesta B. En el adulto mayor la respuesta febril está atenuada por alteración de la termorregulación, y muchas infecciones graves cursan sin fiebre, manifestándose como confusión, caídas o taquipnea. Con hipotensión, taquipnea, lactato elevado y foco urinario corresponde manejar como sepsis: hemocultivos, urocultivo, antibióticos precoces y fluidos.

▶ VER CLASE 1.07.3.002 Complicaciones en el adulto mayor hospitalizado

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.21 · Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente

QUÉ HAY QUE SABER

- La hospitalización en el anciano produce deterioro funcional en 30–50% (pérdida de AVD), incluso con la enfermedad de base resuelta.
- Complicaciones principales: delirium, caídas, úlceras por presión, desnutrición, inmovilidad y sarcopenia, incontinencia y sondas innecesarias, infecciones asociadas a la atención (ITU por catéter, neumonía aspirativa), TVP y reacciones adversas a fármacos.
- Prevención del delirium (modelo HELP): orientación, lentes y audífonos, sueño protegido, movilización precoz, hidratación, evitar benzodiacepinas y anticolinérgicos, familia presente.
- Movilización y sedestación desde el primer día, kinesiología, evitar reposo absoluto y sujeción física; evaluar deglución y nutrición; retirar sonda Foley lo antes posible.
- Revisión de fármacos (Beers/STOPP), ajuste a función renal (Cockcroft-Gault), tromboprofilaxis cuando corresponde, prevención de úlceras con escala de Braden.
- Planificar el alta precozmente: valoración geriátrica, red de apoyo y cuidador, rehabilitación y control en APS.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 82 años se hospitaliza para cirugía de fractura de cadera. Usa lentes y audífonos y tiene deterioro cognitivo leve. El equipo quiere reducir el riesgo de la complicación más frecuente del adulto mayor hospitalizado en este contexto. **¿Cuál es la medida más eficaz para prevenir el delirium?**

A Haloperidol profiláctico nocturno

B Benzodiacepina para asegurar el sueño

C Medidas no farmacológicas: reorientación, uso de lentes y audífonos, movilización precoz, higiene del sueño e hidratación

D Contención física preventiva

E Mantener la luz encendida toda la noche para vigilancia

Respuesta C. El delirium es la complicación más frecuente del adulto mayor hospitalizado, sobre todo tras una fractura de cadera. Las intervenciones no farmacológicas multicomponente (reorientación, lentes y audífonos, movilización, sueño nocturno, hidratación, evitar sondas y contenciones) reducen su incidencia en cerca de un tercio. El haloperidol profiláctico no ha demostrado beneficio y las benzodiacepinas lo precipitan.

▶ VER CLASE 1.07.3.003

Manejo, cuidado y acompañamiento de final de vida

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.26 · Cuidados Paliativos, Dolor Crónico y Final de Vida

QUÉ HAY QUE SABER

- Cuidados paliativos: enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes con enfermedades avanzadas y sus familias, controlando síntomas y apoyando aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Ley 21.375 garantiza cuidados paliativos universales en enfermedades terminales o graves.
- Dolor: escalera analgésica OMS (paracetamol/AINE → tramadol o codeína → morfina); morfina oral 5–10 mg c/4 h con rescates, con laxante profiláctico siempre; ajustar en insuficiencia renal. GES alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado.
- Otros síntomas: disnea (morfina en dosis bajas, ventilador), náuseas (metoclopramida, haloperidol), estertores (butilescopolamina), delirium terminal (haloperidol, midazolam si refractario), boca seca (cuidados locales).
- Últimos días: suspender fármacos y exámenes fútiles, vía subcutánea, no forzar alimentación ni hidratación, sedación paliativa solo ante síntomas refractarios con consentimiento.
- Comunicación: información honesta y gradual, planificación anticipada de decisiones y voluntades, respeto a la autonomía (Ley 20.584 de derechos y deberes), adecuación del esfuerzo terapéutico.
- Acompañar a la familia: apoyo al cuidador, prevenir claudicación familiar y seguimiento del duelo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 14

Un paciente de 80 años en cuidados paliativos por cáncer de glotis presenta, desde hace un mes, tos y regurgitación de alimentos. No ha presentado neumonías aspirativas ni otras complicaciones. **¿Cuál es la vía de administración de medicamentos más adecuada para este paciente?**

A Rectal
B Sublingual
C Intramuscular
D Endovenosa
E Subcutánea

Respuesta E. En cuidados paliativos, cuando la vía oral no es segura, la vía de elección es la subcutánea: es poco dolorosa, permite bolos o infusión continua de morfina, antieméticos y otros fármacos, y la familia puede manejarla en domicilio. La intramuscular es dolorosa, la endovenosa requiere acceso venoso y es más invasiva, y la rectal y la sublingual tienen absorción errática.

▶ VER CLASE 1.07.3.004

Ejercicio en personas mayores

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.22 · Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- El ejercicio es la intervención más eficaz para prevenir y revertir fragilidad, sarcopenia, caídas y deterioro funcional; también mejora ánimo, cognición, control de DM e HTA y densidad ósea.
- Recomendación OMS ≥65 años: 150–300 min/semana de actividad aeróbica moderada + fortalecimiento muscular ≥2 días/semana + ejercicio multicomponente de equilibrio ≥3 días/semana.
- Programa multicomponente (Vivifrail): fuerza contra resistencia (levantarse de la silla, bandas elásticas, cuádriceps y glúteos), equilibrio (estación unipodal, marcha en tándem), marcha y flexibilidad.
- Iniciar con baja intensidad y progresar; adaptar a la capacidad funcional y comorbilidades; incluso en frágiles y en residencias produce beneficios.
- Precauciones: evaluar dolor torácico, síncope o disnea de esfuerzo antes de ejercicio vigoroso; calzado adecuado, hidratación y evitar temperaturas extremas.
- Programas chilenos: Más Adultos Mayores Autovalentes (APS), talleres comunales y recomendaciones del EMPAM.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 70 años, autovalente, con hipertensión controlada y sin cardiopatía, consulta en APS porque desea mantenerse activo. Hoy solo camina 15 minutos 2 veces por semana. Examen físico y EFAM normales. **¿Cuál es la recomendación de actividad física más adecuada?**

A Caminar 20 minutos 3 veces por semana como única actividad
B Al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, ejercicios de fuerza 2 o más días y de equilibrio 3 o más días por semana
C Evitar los ejercicios de fuerza por el riesgo de lesión
D Solo actividad aeróbica intensa, sin fuerza ni equilibrio
E Mantener su nivel actual, ya que a esta edad el ejercicio no modifica el riesgo

Respuesta B. En las personas mayores se recomienda al menos 150 a 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, ejercicios de fortalecimiento muscular 2 o más días y actividad multicomponente con énfasis en equilibrio 3 o más días por semana, para prevenir caídas, sarcopenia y dependencia. El entrenamiento de fuerza es seguro y especialmente útil a esta edad.

▶ VER CLASE 1.07.3.005

Envejecimiento saludable y promoción del autocuidado

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.14 · Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

QUÉ HAY QUE SABER

- Envejecimiento saludable (OMS): proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez; el objetivo es la funcionalidad, no la ausencia de enfermedad.
- Pilares: actividad física regular, alimentación saludable, no fumar, consumo bajo o nulo de alcohol, sueño adecuado, control de PA, glicemia y lípidos, salud bucal, visión y audición.
- Reserva cognitiva y prevención de demencia: estimulación cognitiva, educación, participación social, corrección de hipoacusia, control de factores vasculares, evitar aislamiento y depresión.
- Autocuidado: adherencia a fármacos, conocer sus enfermedades, prevención de caídas en el hogar, vacunación, uso de ayudas técnicas, planificación anticipada de decisiones.
- EMPAM (Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor) anual desde los 65 años en APS: EFAM-Chile clasifica en autovalente sin riesgo, autovalente con riesgo o en riesgo de dependencia; también mide PA, glicemia, visión, audición, ánimo y cognición.
- Programas: Más Adultos Mayores Autovalentes, PACAM (alimentación complementaria), SENAMA y Vínculos para mayores vulnerables.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 97

Prevención de deterioro cognitivo en adultos mayores de entre 60 y 75 años. **¿Cuál de las siguientes medidas se considera más adecuada para prevenir el deterioro cognitivo en adultos mayores de entre 60 y 75 años?**

A Higiene del sueño

B Terapia de relajación

C Ejercicio físico y estudio activo

D Actividades manuales frecuentes

E Administración oral de vitamina C y folatos

Respuesta C. La actividad física regular y la estimulación cognitiva activa (estudio, aprendizaje, vida social) son las intervenciones con mejor evidencia para reducir el riesgo de deterioro cognitivo, junto con controlar los factores de riesgo vascular, la hipoacusia y el aislamiento. La suplementación vitamínica no ha demostrado beneficio en personas sin déficit.

▶ VER CLASE 1.07.3.006 Inmunizaciones en personas mayores

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.3 · Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026

QUÉ HAY QUE SABER

- PNI Chile para ≥65 años: vacuna antineumocócica (polisacárida 23-valente, dosis única a los 65 años, o según esquema vigente con conjugada) y antiinfluenza anual en la campaña de invierno.
- COVID-19: refuerzo según campaña anual, prioritario en ≥60 años y enfermos crónicos.
- Otras recomendadas: dTpa/dT de refuerzo cada 10 años y ante heridas de riesgo; herpes zóster (vacuna recombinante) recomendada en ≥50–65 años según disponibilidad.
- La inmunosenescencia reduce la respuesta a las vacunas, pero siguen siendo eficaces en disminuir neumonía, hospitalizaciones y mortalidad; no hay edad máxima para vacunarse.
- Contraindicaciones verdaderas: anafilaxia previa a la vacuna o componente; las vacunas vivas (por ejemplo, fiebre amarilla) se evitan en inmunosuprimidos. Fiebre leve o resfrío no contraindican.
- Aprovechar cada control (EMPAM, programa cardiovascular, hospitalización) para revisar y completar el esquema; vacunar también a cuidadores.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 66 años, sana, consulta en su CESFAM en abril y pregunta qué vacunas le corresponden según el Programa Nacional de Inmunizaciones. No ha recibido vacunas en la adultez. **¿Cuál es la indicación más adecuada?**

A Solo vacuna antitetánica cada 5 años

B Vacuna anual contra influenza y vacuna antineumocócica

C Vacuna contra hepatitis A y tres vírica

D Refuerzo de vacuna BCG

E Ninguna, porque las vacunas no son eficaces en adultos mayores

Respuesta B. El PNI chileno indica a las personas de 65 años y más la vacuna antineumocócica y la vacunación anual contra influenza en la campaña de invierno, además de COVID-19 según campaña. Reducen neumonía, hospitalización y muerte. BCG y tres vírica no corresponden a esta edad, y la antitetánica se indica según heridas y esquemas previos.

▶ VER CLASE 1.07.3.007 Manejo de fármacos en la persona mayor

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.24 · Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor

QUÉ HAY QUE SABER

- Cambios farmacocinéticos: más grasa y menos agua corporal (diazepam se acumula, digoxina/litio aumentan concentración), menor metabolismo hepático y menor filtrado glomerular (creatinina normal engaña: calcular Cockcroft-Gault).

- Polifarmacia (≥5 fármacos): aumenta reacciones adversas, caídas, delirium, interacciones y mala adherencia. Cascada de prescripción: tratar un efecto adverso con otro fármaco (amlodipino → edema → furosemida).
- Criterios de Beers/STOPP: evitar benzodiacepinas e hipnóticos Z, anticolinérgicos (clorfenamina, amitriptilina, oxibutinina), AINE crónicos, glibenclamida, antipsicóticos en demencia salvo necesidad, metoclopramida.
- Principios: empezar con dosis bajas y subir lento ('start low, go slow'), indicación clara para cada fármaco, simplificar esquemas, revisar todos los medicamentos (incluidos sin receta y hierbas) en cada control.
- Desprescripción activa: suspender lo que no tiene indicación o cuyo riesgo supera el beneficio (por ejemplo, glibenclamida con HbA1c baja, IBP sin indicación); retiro gradual de benzodiacepinas.
- Considerar cognición, visión y destreza para la adherencia; usar pastilleros y apoyo del cuidador.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 9

Paciente 80 años con antecedente de artrosis en tratamiento con paracetamol 1 gr c/8 horas, con control parcial del dolor. Realiza adecuadamente sus actividades de la vida diaria, usa bastón y sale acompañada. Tiene antecedente de HTA e Insuficiencia cardíaca congestiva en capacidad funcional III. **¿Cuál es el mejor fármaco a agregar para continuar el manejo del dolor?**

A Ibuprofeno v.o.

B Pregabalina v.o.

C Ketorolaco v.o.

D Lidocaína en parches

E Tramadol v.o.

Respuesta E. En una adulta mayor hipertensa y con insuficiencia cardíaca, los AINE (ibuprofeno, ketorolaco) se evitan por el riesgo de insuficiencia renal aguda. Se agrega tramadol.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 121

Un paciente de 80 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, hipotiroidismo y artrosis, en tratamiento con donepecilo, levotiroxina y paracetamol, presenta escapes frecuentes de orina y diarrea. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Agregar memantina

B Disminuir la dosis de levotiroxina

C Agregar oxibutinina

D Disminuir la dosis de donepecilo

E Aumentar la dosis de levotiroxina

Respuesta D. Diarrea e incontinencia urinaria son efectos colinérgicos del donepezilo: se reduce su dosis. Agregar oxibutinina (anticolinérgico) contrarresta el fármaco en vez de corregir la causa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 127

Un paciente de 82 años, con múltiples patologías con tratamiento farmacológico, presenta TSH: 3,8 UI/L y hemoglobina glicosilada de 5,2%. **¿Qué fármaco debe suspender?**

A Vitamina D

B Glibenclamida

C Enalapril

D Levotiroxina

E Calcio

Respuesta B. En el mayor de 75 años la meta de HbA1c es más laxa (< 8 %). Con 5,2 % está sobretratado y la glibenclamida conlleva riesgo de hipoglicemia grave: se suspende. La TSH de 3,8 es adecuada para la edad.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 82 años, hipertensa, con artrosis de rodillas e insomnio. Toma losartán, clonazepam 1 mg en la noche, paracetamol 1 g c/8 h, ibuprofeno 400 mg c/8 h (desde hace 3 semanas) y clorfenamina 4 mg en la noche "para dormir". Creatinina 1,6 mg/dL (basal 0,9), K 5,2 mEq/L, PA 165/95. Ha tenido dos caídas nocturnas y pierde gotas de orina al toser o reír. **¿Cuál es la conducta prioritaria?**

A Agregar amlodipino y oxibutinina

B Suspender ibuprofeno y clorfenamina, retiro gradual del clonazepam y ejercicios de Kegel

C Suspender bruscamente el clonazepam e iniciar zolpidem

D Cambiar ibuprofeno por ketorolaco y derivar a urología

E Mantener los fármacos y solicitar ecografía renal

Respuesta B. Polifarmacia con fármacos de Beers: el ibuprofeno produjo falla renal aguda, hiperkalemia y alza de PA; clonazepam y clorfenamina suman carga sedante y anticolinérgica y explican las caídas. La pérdida al toser o reír es incontinencia de esfuerzo. Conducta: suspender ibuprofeno y clorfenamina, retiro gradual del clonazepam, paracetamol como base y Kegel.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 108

Un paciente de 81 años presenta insomnio de conciliación y de mantención, que afecta sus actividades y lo tiene angustiado. Refiere que no duerme siesta. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo de su insomnio?

A Clonazepam
B Diazepam
C Midazolam
D Alprazolam
E Zolpidem

Respuesta E. La verdad es que todos los hipnóticos se deben evitar en el adulto mayor, por el riesgo de dependencia y lo más importante es indicar medidas generales de higiene del sueño. Si hay que elegir un hipnótico en el adulto mayor, debe ser el zolpidem, sin embargo sirve más para el insomnio de concialición y el paciente también tiene de mantención. Esta pregunta está mala, ya que sí se le pueden dejar benzodiacepinas a los adultos mayores y la evidencia no es concluyente. Igualmente creo que zolpidem...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 160

Una mujer de 86 años, con múltiples patologías crónicas, en tratamiento farmacológico, acude a control, constatándose IMC: 23,frecuencia cardíaca: 76 lpm, presión arterial: 110/70 mmHg. Además trae exámenes, que muestran TSH: 2,65 UI/L, LDH: 152 UI/L, hemoglobina glicosilada: 5,2%, colesterol HDL: 35 mg/dl, colesterol total: 205 mg/dl. ¿Qué fármaco debería suspenderse?

A Losartán
B Atorvastatina
C Levotiroxina
D Carvedilol
E Glibenclamida

Respuesta E. Tiene una HbA1c menor a 7%, de hecho, menor a 6%, que es lo normal. En el adulto mayor el objetivo es de 8%, por lo que no hay problema en suspender la glibenclamida y más aún, se puede disminuir el riesgo de hipoglicemias. Ninguno de los demás fármacos está contraindicado.

▶ VER CLASE 1.07.3.008 Nutrición en las personas mayores

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.22 · Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Requerimientos: energía 30 kcal/kg/día y proteínas 1,0–1,2 g/kg/día en sanos (1,2–1,5 g/kg/día en enfermedad aguda, fragilidad o sarcopenia), repartidas en las comidas.
- Calcio 1000–1200 mg/día (3 lácteos) y vitamina D 800–1000 UI/día; líquidos 1,5–2 L/día programados por menor sensación de sed; fibra para prevenir constipación.
- Riesgos nutricionales: anorexia del envejecimiento, problemas dentales y disfagia, depresión, demencia, polifarmacia, pobreza, aislamiento y dietas restrictivas innecesarias.
- Tamizaje: peso e IMC (normal en adultos mayores 23–27,9 kg/m²), baja de peso involuntaria, MNA y circunferencia de pantorrilla; evaluar salud bucal y deglución.
- Obesidad sarcopénica: evitar dietas hipocalóricas sin ejercicio de fuerza y aporte proteico, pues aceleran la pérdida muscular.
- PACAM: programa de alimentación complementaria del adulto mayor (≥70 años, o ≥60 en situaciones definidas) entrega 'Bebida Láctea' y 'Crema Años Dorados' en APS.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 78 años, autovalente y sin enfermedad renal, presenta sarcopenia leve en la valoración geriátrica. Su dieta es pobre en carnes y lácteos. **¿Cuál es el aporte proteico diario recomendado para este paciente?**

A 1,0 a 1,2 g/kg/día
B 0,6 g/kg/día
C 0,4 g/kg/día
D 2,5 a 3 g/kg/día
E No requiere proteínas adicionales, solo vitaminas

Respuesta A. Las personas mayores necesitan más proteínas que los adultos jóvenes para mantener la masa muscular, por resistencia anabólica: se recomienda 1,0 a 1,2 g/kg/día, y hasta 1,5 en enfermedad aguda o sarcopenia, salvo enfermedad renal avanzada. Debe combinarse con ejercicio de resistencia. Un aporte de 0,6 corresponde a restricción en enfermedad renal crónica.

▶ VER CLASE 1.07.3.009 Prevención del deterioro funcional

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.22 · Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Objetivo central de la geriatría: mantener la capacidad funcional (actividades básicas e instrumentales); las instrumentales (Lawton) se pierden antes que las básicas (Barthel).
- Detección precoz en el EMPAM con EFAM-Chile (autovalente sin riesgo, con riesgo, en riesgo de dependencia) y evaluación de dependencia con índice de Barthel.
- Factores de riesgo modificables: sedentarismo, sarcopenia, fragilidad, caídas, déficit visual y auditivo, deterioro cognitivo, depresión, polifarmacia, desnutrición, aislamiento social y hospitalizaciones.
- Intervenciones: ejercicio multicomponente, nutrición con proteínas suficientes, corrección sensorial (lentes, catarata, audífonos), desprescripción, prevención de caídas y adecuación del hogar.
- En hospitalización: movilización precoz, evitar reposo en cama, sondas y sujeción, prevenir delirium y planificar el alta con rehabilitación.
- Programas: Más Adultos Mayores Autovalentes, atención domiciliaria para dependencia severa, ayudas técnicas GES y Cuidados Domiciliarios/Chile Cuida.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 84 años, autovalente, camina sin ayuda y vive con su esposa. Se hospitaliza en sala por una neumonía; al segundo día está estable, afebril, lúcido y tolera la vía oral. El equipo de enfermería propone medidas para la estadía. **¿Cuál de las siguientes medidas previene mejor el deterioro funcional asociado a la hospitalización?**

A Movilización precoz, sentarlo fuera de la cama y caminar diariamente, con nutrición adecuada

B Instalar sonda Foley para evitar que se levante de noche

C Reposo absoluto en cama hasta completar los antibióticos

D Sujeción mecánica nocturna para prevenir caídas

E Benzodiacepina nocturna para asegurar el sueño

Respuesta A. En la persona mayor hospitalizada el reposo en cama produce pérdida rápida de masa muscular y funcionalidad, incluso en pocos días. Se previene con movilización precoz y diaria, aporte proteico, uso de lentes y audífonos, y orientación. Sondas, sujeciones y benzodiacepinas favorecen inmovilidad, delirium y caídas, y deben evitarse.

▶ VER CLASE 1.07.3.010 Sexualidad en personas mayores

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.12 · Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos

QUÉ HAY QUE SABER

- La sexualidad se mantiene en la vejez y es parte de la calidad de vida; preguntar en forma activa y sin prejuicios en la consulta.
- Mujer: atrofia vulvovaginal (síndrome genitourinario de la menopausia) con dispareunia y sequedad; tratamiento con lubricantes, hidratantes vaginales y estrógeno local en dosis bajas.
- Hombre: disfunción eréctil frecuente y marcador de enfermedad cardiovascular; inhibidores de PDE-5 (sildenafil 25–50 mg, tadalafilo), contraindicados con nitratos.
- Fármacos que alteran la sexualidad: antidepresivos ISRS, betabloqueadores, tiazidas, antipsicóticos, antiandrógenos, benzodiacepinas; evaluar cambio o ajuste.
- Condiciones que influyen: depresión, DM, enfermedad cardiovascular (la actividad sexual es segura si tolera ejercicio moderado), artrosis, incontinencia, demencia y pérdida de pareja.
- Prevención de ITS: el uso de preservativo sigue indicado con parejas nuevas; aumentan VIH y sífilis en mayores; ofrecer tamizaje.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 67 años, con pareja estable, consulta por dolor en las relaciones sexuales y sequedad vaginal de 1 año. Al examen se observa mucosa vaginal pálida, delgada y con pérdida de pliegues. No tiene sangrado ni flujo anormal. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Explicar que la actividad sexual no es esperable a esta edad

B Biopsia de vulva

C Terapia hormonal sistémica con estrógenos y progestágeno

D Clotrimazol vaginal

E Estrógenos vaginales en dosis bajas, además de lubricantes

Respuesta E. La dispareunia por síndrome genitourinario de la menopausia (atrofia vulvovaginal) se trata con lubricantes, hidratantes y estrógenos vaginales en dosis bajas, de mínima absorción sistémica. La sexualidad sigue siendo una dimensión vigente en las personas mayores y debe abordarse sin prejuicios. La terapia sistémica no se indica solo por síntomas vaginales a esta edad.

▶ VER CLASE 1.07.3.011 Adecuación del entorno para personas mayores

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.23 · Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES

QUÉ HAY QUE SABER

- La mayoría de las caídas ocurre en el hogar; los factores extrínsecos (entorno) son modificables y su corrección reduce caídas, sobre todo en personas de alto riesgo.
- Baño: barras de apoyo junto al inodoro y ducha, piso antideslizante, alzador de WC, silla de ducha; evitar tinas sin apoyo.

- Dormitorio y pasillos: buena iluminación con luz nocturna, interruptores accesibles, retirar alfombras sueltas y cables, cama a altura adecuada, despejar los recorridos.
- Escaleras con pasamanos a ambos lados, peldaños señalizados; objetos de uso diario al alcance (evitar subirse a sillas); calzado cerrado con talón y suela antideslizante.
- Ayudas técnicas adecuadas (bastón, andador) y teleasistencia o botón de alarma para quien vive solo; terapeuta ocupacional puede hacer visita domiciliaria.
- Entorno social y urbano: accesibilidad, transporte, espacios comunitarios (ciudades amigables con las personas mayores, OMS) y apoyo al cuidador.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 81 años con osteoporosis ha tenido 2 caídas en su casa durante el último año, ambas de noche al ir al baño. Vive en una casa con alfombras sueltas y escalones sin baranda. **¿Cuál es la medida de adecuación del entorno más adecuada?**

A Indicar una benzodiacepina para que no se levante de noche

B Mantener la casa en penumbra para no alterar el sueño

C Indicarle que camine de noche con calcetines de lana

D Retirar alfombras sueltas, instalar iluminación nocturna y barras de apoyo en el baño

E Restringir la ingesta de agua durante todo el día

Respuesta D. Adecuar el entorno es eficaz para prevenir caídas: retirar alfombras sueltas y obstáculos, iluminar de noche el trayecto al baño, instalar barras de apoyo, pisos antideslizantes y barandas. Las benzodiacepinas aumentan el riesgo de caídas, igual que los calcetines sin suela antideslizante y la penumbra. Restringir líquidos predispone a deshidratación.

▶ VER CLASE 1.07.3.012 **Derecho GES a ayudas técnicas para personas de 65 años o más, como órtesis**

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.2 · Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos

QUÉ HAY QUE SABER

- GES de órtesis o ayudas técnicas para personas de 65 años y más (FONASA e ISAPRE) con indicación médica según necesidad funcional.
- Elementos garantizados: bastón, andador (incluido el andador de paseo), silla de ruedas y cojín y colchón antiescaras.
- No incluye: camas eléctricas, salvaescaleras, scooters eléctricos ni plantillas ortopédicas.
- Garantías: acceso, oportunidad (plazos de entrega definidos según el elemento tras la confirmación), protección financiera y calidad; el médico realiza la indicación y la notificación GES.
- Indicación típica: trastorno de marcha o equilibrio, riesgo de caídas, inmovilidad o dependencia con riesgo de úlceras por presión.
- Educar el uso correcto: bastón en la mano contraria a la extremidad afectada y altura a nivel del trocánter mayor (codo flectado ~20–30°).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 72 años, beneficiario de FONASA, con artrosis de cadera y alteración del equilibrio, tiene dificultad para desplazarse en forma segura. Su médico considera que necesita una ayuda técnica. **¿Cuál de los siguientes elementos está garantizado por el GES de órtesis o ayudas técnicas para personas de 65 años y más?**

A Silla salvaescaleras

B Cama clínica eléctrica

C Andador

D Scooter eléctrico

E Plantillas ortopédicas de silicona

Respuesta C. El GES de órtesis o ayudas técnicas para personas de 65 años y más garantiza, según indicación médica, bastones, andadores (incluido el andador de paseo), sillas de ruedas y cojín y colchón antiescaras, con plazos definidos de entrega. Camas eléctricas, salvaescaleras y scooters no forman parte de esta garantía.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

4 códigos

▶ VER CLASE 1.07.5.001 **Valoración afectiva** NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.22 · Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Valoración afectiva: detectar depresión y ansiedad, frecuentes y subdiagnosticadas en el adulto mayor; forma parte de la Valoración Geriátrica Integral y del EMPAM.
- Instrumento: escala de depresión geriátrica de Yesavage (GDS-15): ≥5 puntos sugiere depresión; versión abreviada de 5 ítems útil en tamizaje.
- Diferenciar de demencia (memoria, inicio insidioso) y delirium (inicio agudo, inatención); la depresión responde 'no sé' y mejora con insistencia (pseudodemencia).
- Evaluar siempre ideación suicida, red de apoyo, duelos y consumo de alcohol o benzodiacepinas.
- En deterioro cognitivo moderado-severo la GDS pierde validez: usar escala de Cornell para depresión en demencia e información del cuidador.

- Tamizaje positivo: confirmar con criterios DSM-5 y derivar a especialista (psiquiatría/geriatría) para valoración completa si severa, psicótica, riesgo suicida o diagnóstico dudoso.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 77 años es evaluada en el examen de medicina preventiva del adulto mayor (EMPAM). Su hija refiere que la nota más aislada y desganada desde hace meses. **¿Cuál es el instrumento más adecuado para la valoración afectiva?**

A Mini-Mental State Examination

B Escala de depresión geriátrica de Yesavage

C Índice de Katz

D Escala de Lawton y Brody

E Timed Up and Go

Respuesta B. La escala de depresión geriátrica de Yesavage, en su versión de 15 preguntas (más de 5 puntos sugiere depresión), es el instrumento de tamizaje afectivo recomendado en la valoración geriátrica integral. El MMSE evalúa cognición, Katz y Lawton miden actividades básicas e instrumentales, y el Timed Up and Go evalúa marcha y riesgo de caídas.

▶ VER CLASE 1.07.5.002 Valoración cognitiva

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.14 · Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

QUÉ HAY QUE SABER

- Valoración cognitiva: detectar deterioro cognitivo y demencia; parte de la Valoración Geriátrica Integral y del EMPAM (MMSE abreviado en el EFAM-Chile).
- Instrumentos de tamizaje: MMSE (Minimental, máx. 30; versión abreviada chilena ≤13 alterado), Pfeiffer (≥3 errores = deterioro), MoCA (<26 alterado, más sensible para deterioro leve), test del reloj y Mini-Cog.
- Ajustar a escolaridad; completar con información de un familiar sobre funcionalidad (cuestionario de actividades funcionales de Pfeffer).
- Antes de concluir demencia, descartar delirium, depresión, déficit sensorial y fármacos; estudiar causas reversibles (TSH, B12, VDRL, neuroimagen).
- Deterioro cognitivo leve: déficit objetivo sin pérdida de funcionalidad; demencia: déficit con compromiso funcional.
- Tamizaje alterado: derivar a especialista (neurología/geriatría) para evaluación neuropsicológica completa y confirmación diagnóstica.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 25

Una paciente de 84 años es traída por su hija debido a que presenta olvidos frecuentes. Su acompañante refiere que la paciente ha olvidado recetas, ya no cocina como antes y tiene dificultades crecientes en el manejo del dinero. Recientemente se desorientó en la calle, por lo que requirió ayuda para volver a casa. Tiene escolaridad incompleta hasta sexto básico. Al examen se observa orientada, cooperadora y sin alteraciones neurológicas. **¿Cuál es el examen más adecuado para la evaluación inicial de esta paciente?**

A Test de Montreal Cognitive Assessment (MOCA)

B Mini-Mental State Examination (MMSE)

C Prueba de Confusion Assessment Method (CAM)

D Test del reloj

E Prueba de memorización de tres palabras

Respuesta B. Sospecha de demencia (pérdida de autonomía para cocinar y manejar dinero) en una paciente de baja escolaridad: el examen inicial es el MMSE, ajustado por escolaridad. El MoCA es más útil para pesquisar DCL; el CAM es para delirium.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 25

Una paciente de 84 años es traída por su hija debido a olvidos frecuentes. La acompañante refiere que ha olvidado recetas, ya no cocina como antes y tiene dificultades crecientes en el manejo del dinero. Recientemente se desorientó en la calle y requirió ayuda para volver a casa. Tiene escolaridad incompleta hasta sexto básico. Al examen está orientada, cooperadora y sin alteraciones neurológicas. **¿Cuál es el examen más adecuado para la evaluación inicial de esta paciente?**

A Montreal Cognitive Assessment (MoCA)

B Mini-Mental State Examination (MMSE)

C Confusion Assessment Method (CAM)

D Test del reloj

E Prueba de memorización de tres palabras

Respuesta B. La sospecha es una demencia, con deterioro de memoria y pérdida de funcionalidad instrumental. El MMSE es el instrumento de elección para la evaluación inicial, ajustado por escolaridad. El MoCA es más sensible para deterioro leve, pero penaliza la baja escolaridad. El CAM y la memorización de tres palabras se usan en delirium, y el test del reloj es complementario.

▶ VER CLASE 1.07.5.003 Valoración de la marcha

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.23 · Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Valoración de la marcha y equilibrio: predice caídas, fragilidad y dependencia; realizar en todo adulto mayor que se cae o tiene miedo a caer.
- Timed Up and Go: levantarse de una silla, caminar 3 m, girar y sentarse; <10 s normal, >12–14 s riesgo de caídas, ≥20 s fragilidad marcada.
- Velocidad de marcha en 4 m: <0,8 m/s es anormal (fragilidad, sarcopenia severa). Estación unipodal <5 s: anormal. Prueba de levantarse 5 veces de la silla >15 s: fuerza baja.
- Observar patrón: base amplia (ataxia), pasos cortos sin braceo (Parkinson), marcha magnética (hidrocefalia normotensiva), steppage (neuropatía), hemiparética, antiálgica; Romberg para componente sensitivo.
- Escala de Tinetti (marcha + equilibrio, máx. 28; <19 alto riesgo) y SPPB para evaluación más completa.
- Si es anormal: derivar a especialista (kinesiología/geriatría/neurología) para evaluación detallada, programa de ejercicio y ayuda técnica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 79 años acude a su EMPAM en el CESFAM. Refiere una caída en el último año. Como parte de la evaluación del riesgo de caídas se le aplicará el test Timed Up and Go. **¿Cómo se realiza correctamente este test?**

A Se cronometra el tiempo que tarda en levantarse de una silla con apoyabrazos, caminar 3 metros, girar, volver y sentarse, a su paso habitual

B Se mide la distancia que camina en 6 minutos

C Se cronometra el tiempo que logra mantenerse sobre un pie con los ojos abiertos

D Se cuenta cuántas veces se levanta de la silla en 30 segundos sin usar los brazos

E Se mide el tiempo que tarda en caminar 10 metros en línea recta lo más rápido posible

Respuesta A. El Timed Up and Go evalúa en una sola prueba la transferencia, la marcha y el giro: la persona se levanta de una silla con apoyabrazos, camina 3 metros a su ritmo habitual (con su ayuda técnica si la usa), gira, vuelve y se sienta. Un tiempo prolongado indica riesgo de caídas. Las demás opciones describen otros tests.

▶ VER CLASE 1.07.5.004 Valoración funcional

NIVEL **REALIZAR**

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.22 · Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Valoración funcional: mide la capacidad de realizar actividades de la vida diaria; es el mejor predictor de pronóstico, institucionalización y mortalidad en el adulto mayor.
- Actividades básicas (ABVD): índice de Barthel (0–100): 100 independiente, 60–95 dependencia leve, 40–55 moderada, 20–35 severa, <20 total; o índice de Katz (bañarse, vestirse, uso del WC, movilidad, continencia, alimentación).
- Actividades instrumentales (AIVD): escala de Lawton y Brody (uso de teléfono, compras, cocina, tareas domésticas, transporte, manejo de fármacos y dinero); son las primeras en perderse en el deterioro cognitivo.
- EFAM-Chile en el EMPAM: clasifica en autovalente sin riesgo, autovalente con riesgo o en riesgo de dependencia; si hay dependencia se aplica Barthel.
- Interpretar la pérdida funcional reciente como un síntoma (delirium, infección, depresión, fármacos) y no como 'vejez'.
- Realizar al ingreso y alta hospitalaria y en controles periódicos para planificar rehabilitación, apoyos y cuidador.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 81 años, viuda, vive sola. Su hija relata que en los últimos 6 meses olvida pagar las cuentas, se equivoca al tomar sus medicamentos y ya no usa el transporte público sola. Se baña, se viste, come y va al baño sin ayuda, y es continente. **¿Qué instrumento es el más adecuado para cuantificar el compromiso funcional descrito?**

A Índice de Barthel

B Test de Pfeiffer

C Índice de Katz

D Escala de depresión geriátrica de Yesavage

E Escala de Lawton y Brody

Respuesta E. Manejar dinero, medicamentos, transporte, teléfono y compras son actividades instrumentales de la vida diaria, que se evalúan con la escala de Lawton y Brody; suelen ser las primeras en perderse. Barthel y Katz miden actividades básicas (baño, vestido, alimentación, continencia), que aquí están conservadas. Yesavage tamiza depresión y Pfeiffer, deterioro cognitivo.

08

HEMATO-ONCOLOGÍA

58 CÓDIGOS

128 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	19
Situaciones clínicas de urgencia	9
Conocimientos generales	12
Exámenes e imagenología	10
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	8

Situaciones clínicas

19 códigos

▶ VER CLASE **1.08.1.001** **Anemia de las enfermedades crónicas**

DX SOSPECHA · TX INICIAL · SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Hematología 8.2 · Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina
Hematología 8.4 · Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en paciente con inflamación crónica (artritis reumatoide, infección prolongada, cáncer, autoinmunidad) y anemia leve a moderada (Hb 8,5–11,5 g/dL), arregenerativa.
- Inicialmente normocítica normocrómica; con los meses puede ser microcítica leve (VCM 72–79 fL). Hb <8 g/dL obliga a buscar otra causa sobreagregada (sangrado).
- Perfil de hierro: ferritina alta (>100 ng/mL), transferrina/TIBC bajas, ferremia baja e IST 15–25 %. Mecanismo: IL-6 → hepcidina → hierro atrapado en macrófagos.
- Ferropenia concomitante si ferritina <100 ng/mL con PCR alta: ahí sí corresponde reponer hierro.
- Tratamiento: controlar la enfermedad de base; no dar hierro empírico (queda atrapado). Diferenciar de anemia renal (VFG <45–60, déficit de EPO).
- Seguimiento completo: hemograma y perfil de hierro periódicos junto al control de la enfermedad de base.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 58

Una paciente de 52 años, con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento permanente con AINES y prednisona por vía oral y tratamiento intermitente con metotrexate por vía oral, presenta un cuadro de astenia, adinamia y disnea de esfuerzos que ha empeorado en el último tiempo. Se solicitan exámenes en los que destacan una creatinina de 1,6mg/dL, hemograma con hematocrito 29%, hemoglobina 9,7g/dL, plaquetas 147.000/mm3, blancos 4.200/mm3 y al frotis se aprecia microcitosis. Además se solicita perfil de fierro que muestra ferremia de 40ug/dL (60-160 ug/dL) y transferrina de 190mg/dL (240-360mg/dL). **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Anemia por enfermedades crónicas
B Mielodisplasia
C Anemia por insuficiencia renal crónica
D Hipoplasia medular
E Mieloma múltiple

Respuesta A. Artritis reumatoide con ferremia baja y transferrina baja: hierro secuestrado por inflamación, anemia de enfermedades crónicas. En la ferropenia la transferrina estaría alta. El dato que decide es la transferrina baja en una paciente con artritis.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 54 años con artritis reumatoide en tratamiento con metotrexato consulta por astenia. Hb 9,4 g/dL, VCM 83 fL, leucocitos 7.800/µL, plaquetas 390.000/µL. Ferremia 32 µg/dL (VN 50–150), transferrina 180 mg/dL (VN 200–360), TIBC 225 µg/dL (VN 250–420), ferritina 380 ng/mL (VN 30–200), saturación 14 %. PCR 24 mg/L. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?**

A Anemia ferropénica; iniciar sulfato ferroso oral
B Anemia de enfermedades crónicas; optimizar el control de la artritis, sin hierro
C Ferropenia concomitante a inflamación; hierro endovenoso
D Hemocromatosis hereditaria; estudio del gen HFE
E Rasgo talasémico; electroforesis de hemoglobina

Respuesta B. Normocítica, con ferritina alta (380) y transferrina y TIBC bajas en una paciente con PCR elevada: hierro secuestrado por inflamación. La ferritina supera 100, así que no hay ferropenia concomitante. Se trata la artritis de base; no está indicado suplementar hierro.

▶ VER CLASE **1.08.1.002** **Anemia ferropénica**

DX ESPECÍFICO · TX COMPLETO · SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Hematología 8.2 · Perfil de Cinética de Hierro: Ferritina, Transferrina, TIBC y Saturación de Transferrina
Hematología 8.3 · Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Clínica: síndrome anémico más signos de ferropenia tisular: coiloniquia, queilitis angular, glositis atrófica, pica (pagofagia). Trombocitosis reactiva frecuente.
- Confirmación: anemia microcítica hipocrómica (VCM <80 fL, HCM <27 pg, RDW >15 %) con ferritina <30 ng/mL; con inflamación, ferritina <100 + IST <15 %. No requiere médula.
- La ferropenia es un síntoma: hombre o mujer posmenopáusica → EDA + colonoscopía obligatorias (cáncer digestivo hasta demostrar lo contrario); mujer fértil con hipermenorrea → causa ginecológica; endoscopías negativas → descartar celiaquía (anti-transglutaminasa IgA).
- Tratamiento: sulfato ferroso 40–100 mg de hierro elemental/día o en días alternos, en ayunas con vitamina C; advertir deposiciones negras. Constipación previa al hierro: colonoscopía.
- Hierro EV (carboximaltosa o sacarato) si malabsorción (bypass, celiaquía, EII), intolerancia grave, ERC 4–5 o pérdidas que superan la absorción. Transfundir solo por clínica (inestabilidad, angina), no por la cifra.
- Seguimiento: pico de reticulocitos a los 5–7 días; mantener hierro 3–6 meses tras normalizar la Hb para repletar depósitos (ferritina).

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 27

Una paciente de 19 años, con antecedentes de sangrado menstrual abundante desde su menarquia a los 12 años y de una cirugía de by pass gástrico realizado hace un año, consulta por un cuadro de disnea e intolerancia al ejercicio, de 4 meses de evolución, que ha ido en aumento. Se solicitan exámenes, entre los que destaca un hemograma con hemoglobina: 9,1 g/dl, hematocrito 28%, blancos: 6.200 por mm3, plaquetas 300.000 por mm3; ferritina plasmática: 9 ng/ml (VN: 12 – 150 ng/ml) y saturación de transferrina 12%. **La conducta más adecuada es:**

A Indicar hierro por vía oral
B Administrar hierro por vía endovenosa
C Administrar folatos orales
D Administrar vitamina B12 por vía intra muscular
E Transfundir glóbulos rojos

Respuesta B. Anemia ferropénica (ferritina 9, saturación 12 %) en una paciente con by-pass gástrico: el hierro se absorbe en el duodeno, que el by-pass excluye. La malabsorción documentada es indicación de hierro endovenoso.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 166

Una paciente de 28 años se encuentra en su quinto día postparto, tras el cual presentó atonía uterina que se manejó farmacológicamente. En el examen físico, presenta palidez de piel y mucosas, por lo que se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 8.6 g/dL y hematocrito: 25%. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Administrar hierro por vía oral
B Administrar hierro por vía endovenosa
C Realizar una transfusión de glóbulos rojos
D Administrar un uterotónico
E Administrar ácido fólico y vitamina B12

Respuesta A. Anemia moderada tras una hemorragia posparto ya controlada, sin inestabilidad: se repone hierro, y la vía oral es la de elección. No hay criterios clínicos de transfusión ni malabsorción que obligue a la vía endovenosa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 27

Paciente de 19 años, con antecedente de sangrado menstrual abundante desde su menarquia a los 12 años y de una cirugía de bypass gástrico realizada hace 1 año, consulta por disnea e intolerancia al ejercicio de 4 meses de evolución, que ha ido en aumento. Hemograma: hemoglobina 9,1 g/dL, hematocrito 28 %, leucocitos 6.200/mm³, plaquetas 300.000/mm³; ferritina plasmática 9 ng/mL (VN 12–150 ng/mL) y saturación de transferrina 12 %. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar hierro por vía oral
B Administrar hierro por vía endovenosa
C Administrar folatos orales
D Administrar vitamina B12 por vía intramuscular
E Transfundir glóbulos rojos

Respuesta B. Ferritina baja y saturación de transferrina bajo 20 %: anemia ferropénica moderada. El bypass gástrico excluye el duodeno, sitio principal de absorción del hierro, por lo que la vía oral será ineficaz: corresponde hierro endovenoso. Sin inestabilidad hemodinámica, no hay indicación de transfundir.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años, fumador ocasional, con 2 meses de disnea de medianos esfuerzos y palpitaciones. Sin dolor abdominal ni deposiciones oscuras. Palidez, FC 96 lpm. Hb 8,1 g/dL, VCM 68 fL, HCM 21 pg, plaquetas 510.000/µL, reticulocitos 0,8 %. Ferritina 8 ng/mL, TIBC 440 µg/dL, saturación 4,5 %. Refiere que hace 4 meses evacua con menor frecuencia. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Transfundir 2 unidades de glóbulos rojos
B Sulfato ferroso oral y control de hemograma en 3 meses
C Sulfato ferroso oral más laxante osmótico
D Sulfato ferroso oral y colonoscopía total más endoscopía digestiva alta prioritarias
E Hierro endovenoso y anticuerpos anti-transglutaminasa

Respuesta D. Anemia ferropénica microcítica, arregenerativa, con trombocitosis reactiva en un hombre de 58 años con cambio del hábito intestinal previo: sangrado digestivo por cáncer de colon hasta demostrar lo contrario. Se inicia hierro oral y se piden con prioridad colonoscopía y EDA. Está estable: no requiere transfusión.

▶ VER CLASE 1.08.1.003 **Anemia hemolítica** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Hematología 8.7 · Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo
Hematología 8.8 · Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)
Hematología 8.9 · Talasemias (Rasgo Beta vs Mayor) y Drepanocitosis / Anemia Falciforme (HbS)
Hematología 8.10 · Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar hemólisis ante anemia regenerativa (IRC >2 %) con LDH alta, bilirrubina indirecta elevada, haptoglobina baja e ictericia; el VCM puede estar algo alto por reticulocitosis.
- Primer paso: hemograma con reticulocitos y frotis; luego Coombs directo. IgG (± C3d) = AHAI caliente (LES, LLC, fármacos); solo C3d = crioaglutininas (Mycoplasma, VEB, linfoma).

- Coombs negativo: esferocitosis (microesferocitos, CHCM >36, colelitiasis joven, esplenomegalia), déficit de G6PD (varón, habas/sulfas/primaquina, cuerpos de Heinz), HPN (hemólisis + trombosis atípica) o microangiopatía (esquistocitos: PTT/SHU).
- Manejo inicial AHAI caliente: prednisona 1–1,5 mg/kg/día (grave: metilprednisolona 1 g EV) y ácido fólico 5 mg/día; crioaglutininas: evitar el frío, no responden a corticoides.
- No transfundir por la cifra (pruebas cruzadas incompatibles): solo con compromiso vital, unidad menos incompatible. Esquistocitos con plaquetopenia es emergencia (no transfundir plaquetas).
- Seguimiento: derivar a hematología para confirmar etiología y segunda línea (rituximab, esplenectomía con vacunas previas).

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 87

Un paciente de 46 años, sin antecedentes, cursa con cuadro de disnea y palidez desde hace 2 semanas, asociado a coluria e ictericia. Al examen físico se aprecian mucosas pálidas y se palpa esplenomegalia, sin otros hallazgos. **El examen de elección para el diagnóstico etiológico en este caso es:**

A Haptoglobina
B LDH
C Coombs
D Hemograma con reticulocitos
E Bilirrubina total e indirecta

Respuesta D. El cuadro sugiere una anemia hemolítica. El estudio parte por el hemograma con reticulocitos, que confirma la anemia y muestra que es regenerativa. Recién después se pide el Coombs directo para buscar la causa autoinmune.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 21

Un paciente de 29 años presenta ictericia, disnea y compromiso marcado del estado general. Su examen físico solo muestra ictericia de escleras y piel, sin alteraciones relevantes en el examen segmentario. Sus exámenes de laboratorio muestran hemograma con hematocrito: 12%, hemoglobina: 4,1 g/dL, plaquetas: 250.000/mm³, glóbulos blancos 7.800/mm³, VCM: 103 fL y CHCM: 32 pg; en el frotis se observa presencia de microesferocitos. Las pruebas hepáticas muestran GOT: 52 U/L, GPT: 56 U/L, bilirrubina total: 4,1 mg/dL, bilirrubina directa 0,5: mg/dL, GGT: 50 U/L, fosfatasas alcalinas: 211 U/L y LDH: 960 U/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hepatitis A
B Anemia por déficit de vitamina B12
C Hemólisis
D Anemia aplásica
E Mielodisplasia

Respuesta C. Anemia aguda y grave con bilirrubina indirecta y LDH elevadas y microesferocitos: hemólisis, probablemente autoinmune. El VCM sube por el aumento de reticulocitos, que son más grandes. El Coombs directo confirma la causa autoinmune.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 21

Paciente de 29 años presenta ictericia, disnea y compromiso marcado del estado general. Al examen físico solo destaca ictericia de escleras y piel, sin alteraciones relevantes en el examen segmentario. Hemograma: hematocrito 12 %, hemoglobina 4,1 g/dL, plaquetas 250.000/mm³, leucocitos 7.800/mm³, VCM 103 fL, CHCM 32 g/dL; en el frotis se observan microesferocitos. Pruebas hepáticas: GOT 52 U/L, GPT 56 U/L, bilirrubina total 4,1 mg/dL, bilirrubina directa 0,5 mg/dL, GGT 50 U/L, fosfatasas alcalinas 211 U/L y LDH 960 U/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hepatitis A
B Anemia por déficit de vitamina B12
C Hemólisis
D Anemia aplásica
E Mielodisplasia

Respuesta C. Anemia aguda y severa con bilirrubina de predominio indirecto, LDH alta y microesferocitos: hemólisis, probablemente autoinmune. El VCM alto se explica por la reticulocitosis. El déficit de B12 no da microesferocitos y suele bajar las plaquetas; la hepatitis A elevaría mucho las transaminasas y la bilirrubina directa.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Paciente de 45 años consulta porque le indicaron que padecía de anemia. El hemograma constata recuento de blancos y plaquetas normales, Hcto: 33%, Hb: 11 g/dl, VCM: 70. En el frotis se aprecia isocitosis y normalidad del índice de dispersión eritrocítica. Se solicita perfil de hierro que resulta normal. **El diagnóstico más probable es:**

A Talasemia
B Anemia ferropénica
C Anemia de enfermedades crónicas
D Anemia hemolítica crónica
E Hemocromatosis

Respuesta A. Microcitosis con anemia leve, isocitosis (RDW normal) y perfil de hierro normal: rasgo talasémico. La ferropenia tendría RDW alto y ferritina baja; la anemia de enfermedades crónicas tendría ferremia baja con ferritina normal o alta y suele ser normocítica.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 31 años con diagnóstico reciente de LES consulta por disnea de reposo, astenia intensa, orinas oscuras e ictericia de 48 horas. PA 100/60 mmHg, FC 115 lpm, lúcida, sin dolor torácico. Palidez intensa, ictericia conjuntival y polo de bazo palpable. Hb 5,8 g/dL, VCM 104 fL, reticulocitos 9,2 %, plaquetas 240.000/µL, bilirrubina indirecta 4,1 mg/dL, LDH 1.340 UI/L, haptoglobina < 5 mg/dL. Frotis: abundantes microesferocitos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Transfundir 2 unidades de glóbulos rojos de inmediato y luego estudiar

B Coombs directo, hospitalizar, metilprednisolona EV 1 g/día y ácido fólico, evitando transfundir

C Esplenectomía de urgencia

D Mantenerla temperada, evitar el frío e iniciar rituximab

E Vitamina B12 IM y ácido fólico oral

Respuesta B. Hemólisis (reticulocitos altos, bilirrubina indirecta, LDH alta, haptoglobina indetectable) con microesferocitos en una paciente con LES: AHAI por anticuerpos calientes, grave (Hb < 7, disnea de reposo). Se confirma con Coombs directo, se hospitaliza con pulsos de metilprednisolona y ácido fólico, y se evita la transfusión mientras no haya shock, ángor ni compromiso de conciencia. La esplenectomía es segunda línea y el manejo del frío corresponde a crioaglutininas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 26 años, asintomático, de ascendencia italiana, en examen preventivo laboral. Hb 11,8 g/dL, VCM 64 fL, HCM 20 pg, glóbulos rojos 5,8 millones/µL, RDW 12,8 % (normal), plaquetas y leucocitos normales. Recibió sulfato ferroso oral por 3 meses sin cambios en el hemograma. Ferritina 140 ng/mL (VN 30–200), saturación de transferrina 32 %. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Cambiar a hierro endovenoso por mala absorción oral

B Suspender el hierro y solicitar electroforesis de hemoglobina

C Solicitar endoscopía y colonoscopía para buscar sangrado

D Duplicar la dosis de sulfato ferroso por 3 meses más

E Solicitar biopsia de médula ósea

Respuesta B. Microcitosis marcada con Hb casi normal, GR 5,8 millones, Mentzer 64/5,8 = 11 (< 13), RDW normal y ferritina normal: rasgo talasémico beta menor. Se suspende el hierro (evitar sobrecarga) y se confirma con electroforesis: HbA2 > 3,5 %.

▶ VER CLASE 1.08.1.004 Anemia megaloblástica

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.6 · Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante anemia macrocítica (VCM típico 110–130 fL), arregenerativa, a veces con pancitopenia, LDH y bilirrubina indirecta altas (eritropoyesis ineficaz), neutrófilos hipersegmentados y glositis.
- Neurología solo en déficit de B12: degeneración combinada subaguda (cordones posteriores, Romberg +, piramidalismo), parestesias, deterioro cognitivo.
- Causas de B12: anemia perniciosa (autoinmune), gastrectomía/bypass, Crohn o resección ileal, veganos estrictos, metformina o IBP crónicos. Folato: alcohol, desnutrición, embarazo, metotrexato.
- Confirmar con B12 <200 pg/mL (límite 200–350: ácido metilmalónico >0,4); folato intraeritrocitario bajo. Perniciosa: anticuerpos anti-factor intrínseco.
- Tratamiento: B12 1.000 µg IM diario por 7 días, luego semanal por 4 semanas y mensual de por vida si hay malabsorción; ácido fólico 1–5 mg/día por 3–4 meses. Nunca ácido fólico solo sin asegurar B12.
- Seguimiento: potasio a las 48–72 h (hipokalemia), crisis reticulocitaria día 5–7, Hb normal en 4–6 semanas; B12 profiláctica de por vida tras gastrectomía o bypass.

PREGUNTAS · 12

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 18

Una paciente de 29 años, sin antecedentes, consulta por disnea progresiva asociada a fatigabilidad. Al examen físico destaca mucosas pálidas, cardiopulmonar normal. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina 8.3mg/dL, hematocrito 26%, VCM 110, reticulocitos 0.3%, leucocitos 8.500/mm3 y plaquetas 200.000/mm3. **El diagnóstico más probable en este caso es:**

A Anemia falciforme

B Anemia perniciosa

C Anemia ferropénica

D Anemia por enfermedades crónicas

E Anemia por déficit de vitamina B6

Respuesta B. VCM 110 con reticulocitos bajos: anemia macrocítica arregenerativa, por falla en la síntesis de ADN. La causa más frecuente de déficit de B12 es la anemia perniciosa. La ferropenia es microcítica y la enfermedad crónica, normocítica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 23

Una paciente de 64 años, con antecedente de by-pass gástrico, por obesidad mórbida, presenta un cuadro de dificultad a la marcha, asociado a astenia y malestar general. En sus exámenes destaca anemia macrocítica, plaquetas: 100.000 por mm3, blancos: 6.000 por mm3, ferritina 56 ug/dl y saturación de transferrina de 18%. **¿El déficit de qué nutriente explica mejor este caso?**

A Fierro
B Ácido fólico
C Cianocobalamina
D Zinc
E Tiamina

Respuesta C. By-pass gástrico, anemia macrocítica con plaquetopenia y compromiso de la marcha: déficit de vitamina B12. La ferritina es normal, así que los depósitos de hierro no están vacíos, y la macrocitosis no calza con ferropenia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 117

Un paciente de 73 años presenta astenia y disnea de esfuerzos importante, asociada a gran palidez de piel y mucosas. Refiere, también, parestesias en las 4 extremidades. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina: 6 mg/dl, VCM: 126 fl, glóbulos blancos: 3.100 por mm3, plaquetas: 105.000 por mm3 y 2 eritroblastos / 100 leucocitos. Se solicitan, además, LDH: 1.800 UI/L y bilirrubina: 5 mg/dl, de predominio indirecto. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Mielodisplasia
B Aplasia medular
C Anemia por déficit de vitamina B12
D Síndrome leucoeritroblástico
E Anemia hemolítica autoinmune

Respuesta C. Pancitopenia con VCM 126 fL, LDH y bilirrubina indirecta muy altas (eritropoyesis ineficaz) y parestesias en las cuatro extremidades: déficit de B12, probablemente por anemia perniciosa. La aplasia no da macrocitosis tan marcada ni neurología, y la hemólisis autoinmune no explica la leucopenia ni la trombocitopenia ni las parestesias.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 133

Un paciente de 71 años consulta por malestar general y disnea progresiva, que actualmente es de pequeños esfuerzos. Al examen físico se observa pálido, con examen cardiopulmonar que muestra ritmo regular en dos tiempos, sin soplos, con frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto; y examen pulmonar que constata murmullo pulmonar simétrico sin otros ruidos. Se solicita hemograma que se informa con hematocrito: 16%, hemoglobina: 5,2 g/dL, VCM: 118 fL, CHCM: 40 g/dL, reticulocitos: 0,8%, plaquetas: 60.000/mm³ y glóbulos blancos: 3.300/mm³. Además, se solicita GOT: 52 U/L, bilirrubina total: 3,5 mg/dL y bilirrubina directa: 0,2 mg/dL. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Anemia megaloblástica
B Anemia aplásica
C Anemia hemolítica
D Mielodisplasia
E Mieloptisis

Respuesta A. VCM 118 fL con pancitopenia y bilirrubina indirecta alta, pero reticulocitos bajos: eritropoyesis ineficaz por déficit de B12, no hemólisis periférica. Con Hb bajo 7 g/dL puede requerir transfusión, además de B12 intramuscular.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 141

Un paciente de 36 años, desde hace 4 años sigue dieta vegana estricta. Consulta por astenia, adinamia y palidez, a lo que se ha agregado disnea de grandes esfuerzos, que ha aumentado. Al examen físico tiene palidez de piel y mucosas, FC: 92x', PA: 100/70 mmHg, sin alteraciones del examen segmentario. Se solicita hemograma que muestra plaquetas: 200.000 por mm3, glóbulos blancos: 6.500 por mm3, hematocrito: 27%, hemoglobina: 9 g/dl, VCM: 115 fl, HCM: 35 pg y reticulocitos 0,5%, con LDH: 450 UI/L. **El examen más adecuado para proseguir el estudio es:**

A Nivel de vitamina B12
B Mielograma
C Biopsia de médula ósea
D Perfil de fierro
E Prueba de Coombs

Respuesta A. Dieta vegana estricta por 4 años (la B12 solo viene de alimentos animales y las reservas duran 3 a 5 años) con anemia macrocítica arregenerativa y VCM 115 fL: el siguiente paso es medir la vitamina B12. La médula ósea no es necesaria para el diagnóstico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 10

Un paciente de 60 años, gastrectomizado, presenta un cuadro de astenia, adinamia, asociada a disminución de la sensibilidad distal de las extremidades y debilidad. Además ha presentado algún grado de disminución de la capacidad cognitiva. Al examen físico se aprecia disminución de los reflejos osteotendíneos, palidez y disminución de la sensibilidad de las Extremidades inferiores. Se solicitan exámenes, entre los que destaca un hemograma con Hemoglobina de 6,3 g/dl, VCM: 110 fl, plaquetas: 200.000 por mm3, blancos: 3.200 por mm3. **La indicación más adecuada es:**

A Ácido fólico
B Vitamina B12
C Fierro
D Biopsia de médula ósea
E Endoscopía digestiva alta

Respuesta B. Gastrectomía: sin factor intrínseco no se absorbe la B12. Tiene anemia macrocítica, neuropatía y compromiso cognitivo, todo explicado por el déficit de B12. El ácido fólico solo sería el error más grave.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 138

Un paciente de 80 años presenta astenia, bradipsiquia, confusión y disnea de mínimos esfuerzos. Al examen físico se aprecia pálido, con FC: 115x, PA: 120/80 mmHg. Se realiza un hemograma, que muestra anemia con hemoglobina: 5,9 g/dl, HCM: 34 pg, VCM: 117 fl, blancos: 3.100 por mm3, plaquetas: 57.000 por mm3 y, además, destaca LDH: 890 UI/L. **El diagnóstico más probable es:**

A Anemia aplástica
B Anemia hemolítica
C Anemia megalobástica
D Mielodisplasia
E Mieloma múltiple

Respuesta C. Pancitopenia con VCM muy elevado (117 fL), LDH alta por eritropoyesis ineficaz y compromiso neurológico (bradipsiquia, confusión): anemia megaloblástica por déficit de B12. La mielodisplasia también da pancitopenia macrocítica en ancianos, pero el compromiso neurológico y la LDH desproporcionada apuntan al déficit de B12, que es más frecuente y reversible.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 74 años con hipotiroidismo y vitíligo consulta por astenia, parestesias en ambos pies y dificultad para caminar en la oscuridad de 5 meses. Palidez con tinte ictérico leve, lengua lisa y depapilada, marcha atáxica con Romberg positivo, reflejos rotulianos exaltados y Babinski bilateral. Hb 7,1 g/dL, VCM 118 fL, plaquetas 110.000/µL, leucocitos 3.200/µL, reticulocitos 0,4 %, LDH 1.200 UI/L, bilirrubina indirecta 2,3 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Ácido fólico 5 mg/día oral y control en un mes
B Prednisona 1 mg/kg por anemia hemolítica autoinmune
C Medir B12 y folato, e iniciar hidroxocobalamina 1.000 µg IM diaria con control de potasio
D Biopsia de médula ósea antes de cualquier tratamiento
E Vitamina B12 oral 1.000 µg/día

Respuesta C. Pancitopenia macrocítica con eritropoyesis ineficaz (LDH y bilirrubina indirecta altas, reticulocitos bajos) y degeneración combinada subaguda, en una paciente con autoinmunidad: anemia perniciosa. Se miden B12 y folato, se piden anticuerpos anti-FI y anti-parietales, y se inicia B12 IM de inmediato vigilando la kalemia. El ácido fólico solo está contraindicado; la vía oral no sirve sin factor intrínseco.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 104

Adulto mayor con astenia, anemia, trombocitopenia, leucopenia, LDH elevada y VCM 123. ¿Diagnóstico más probable?

A Leucemia aguda
B Síndrome mielodisplásico
C Anemia aplásica
D Anemia megaloblástica
E Linfoma no Hodgkin con compromiso medular

Respuesta D. Diagnóstico: Anemia megaloblástica (opción D). Anemia megaloblástica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 116

Una paciente de 27 años, vegana estricta, con antecedente de cirugía bariátrica, presenta astenia y disnea de esfuerzos, asociado a palidez, por lo que se solicita un hemograma, con hematocrito: 23%, hemoglobina: 7,1 g/dl, VCM: 122 fl, blancos: 4.100 por mm3 y plaquetas: 150.000 por mm3. ¿El déficit de qué elemento puede explicar los síntomas y hallazgos de laboratorio?

A Hierro
B Folatos
C Zink
D Vitamina B12
E Vitamina D

Respuesta D. Tanto por ser vegetariana, como por la cirugía bariátrica, como por el VCM mayor a 108, es un défict de B12.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 67

Paciente masculino de 88 años de edad quien consulta por astenia de 3 meses de evolución. Al examen físico se observa palidez de piel y mucosas y leve tinte ictérico en escleras. Hemograma: Hemoglobina 6,6 grs/dl; hematocrito: 17%; VCM : 117 fl; plaquetas: 110.000 por mm3; glóbulos blancos: 3.400 x mm3; fórmula diferencial: neutrófilos: 74 %, linfocitos: 20 %, eosinófilos: 5 % y baciliformes: 1 %. El examen para confirmar el diagnóstico es:

A Mielograma
B Citometría de flujo
C Prueba de Coombs
D Niveles de Eritropoyetina.
E Niveles de vitamina B12 y Ácido fólico.

Respuesta E. Era una anemia perniciosa clásica, con la macrocitosis y pancitopenia clásicas. Se estudia con B12 (cianocobalamina) y B9 (folatos).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 173

Adulto mayor con alteraciones de memoria y VCM > 100

A Déficit de vitamina B12
B Ninguna de las anteriores es correcta
C Todas las anteriores son correctas
D No se dispone de información suficiente
E Otra alternativa no descrita

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Déficit de vitamina B12).

▶ VER CLASE 1.08.1.005 Coagulopatías adquiridas

DX SOSPECHA · TX INICIAL · SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.14 · Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante sangrado en paciente con hepatopatía, colestasis, malabsorción, antibióticos prolongados, uso de anticoagulantes o cuadro grave (sepsis, obstetricia, trauma) que sugiera CID.
- Déficit de vitamina K: cae primero el factor VII → TP prolongado (luego TTPK); corrige con vitamina K1 en 12–24 h. En colestasis usar vitamina K parenteral.
- Daño hepático: TP largo con factor V bajo, no corrige con vitamina K. CID: plaquetas bajas, TP y TTPK largos, fibrinógeno bajo y dímero D alto (score ISTH ≥5).
- Cumarínicos: INR 4,5–10 sin sangrado → suspender 1–2 dosis; INR >10 o sangrado leve → vitamina K oral 2,5–5 mg; sangrado grave → complejo protrombínico 25–50 UI/kg + vitamina K 10 mg EV lenta.
- Antídotos: dabigatrán → idarucizumab; anti-Xa → andexanet o CCP; heparina no fraccionada → protamina (1 mg neutraliza 100 UI).
- Seguimiento: derivar a hematología o especialista de la enfermedad de base según la causa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 66 años con ictericia indolora progresiva de 5 semanas, coluria, acolia y prurito. Baja de 8 kg. Ecografía: dilatación de la vía biliar intra y extrahepática; TAC con masa en cabeza de páncreas. Se programa drenaje biliar. Hb 12,9 g/dL, plaquetas 280.000/µL, TP 42 % (INR 2,0), TTPK 38 s (control 30 s), fibrinógeno 380 mg/dL, albúmina 3,6 g/dL. Sin sangrado activo. **¿Cuál es la causa más probable de la alteración de la coagulación y su manejo?**

A Déficit de vitamina K por colestasis; vitamina K por vía parenteral y controlar el TP
B Insuficiencia hepática; transfundir plasma fresco congelado
C Coagulación intravascular diseminada; iniciar heparina
D Hemofilia adquirida; solicitar inhibidor del factor VIII
E Enfermedad de von Willebrand adquirida; desmopresina

Respuesta A. La colestasis impide absorber vitaminas liposolubles: falta vitamina K y bajan los factores II, VII, IX y X, prolongando sobre todo el TP. Con albúmina, plaquetas y fibrinógeno normales, no es insuficiencia hepática ni CID. Se corrige con vitamina K parenteral (no oral, por la malabsorción), con mejoría del TP en 24–48 horas.

▶ VER CLASE 1.08.1.006 Coagulopatías congénitas (hemofilias, von Willebrand)

DX SOSPECHA · TX INICIAL · SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.13 · Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemofilia A (factor VIII, 85 %) y B (IX, 15 %): ligadas al X, varones; antecedente de tío materno o hermano que sangra (hasta 30 % de novo).
- Sospechar ante hemartrosis (rodilla, codo, tobillo), hematomas musculares profundos (psoas, síndrome compartimental) o sangrado posquirúrgico tardío; TTPK prolongado aislado que corrige con la mezcla, TP y plaquetas normales.
- Von Willebrand: la coagulopatía hereditaria más frecuente, autosómica dominante, sangrado mucocutáneo (epistaxis, menorragia); TTPK normal o levemente largo; perfil: antígeno, cofactor de ristocetina y VIII.
- Manejo inicial del sangrado en hemofilia: infundir concentrado de factor de inmediato, antes de imágenes (hemartrosis VIII 25–30 UI/kg, meta 40–50 %; SNC meta 100 %). Hemofilia está cubierta por GES.

- Von Willebrand tipo 1: desmopresina (vigilar hiponatremia); ácido tranexámico en sangrado oral. Nunca AINE ni aspirina, ni inyecciones IM, ni puncionar la hemartrosis.
- Seguimiento: derivar a hematología (centro de hemofilia) para profilaxis y control.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 164

Paciente con epistaxis, equimosis, gingivorragias frecuentes, antecedente familiar de epistaxis y menorragias, TTPA levemente prolongado. **¿Diagnóstico más probable?**

A Trombocitopenia inmune primaria (PTI)
B Hemofilia A
C Déficit de factor XI
D Enfermedad de Von Willebrand
E Coagulación intravascular diseminada (CID)

Respuesta D. Sangrado mucocutáneo, familiares de ambos sexos afectados (herencia autosómica dominante) y TTPA levemente prolongado: enfermedad de von Willebrand. La hemofilia da hemartrosis y TTPA francamente largo, y se hereda por línea materna a varones.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 130

Un paciente de 18 años presenta equimosis frecuente y tendencia a presentar petequias en las extremidades inferiores. Como antecedente, presentó hemorragia tardía, en relación a la extracción de un molar y hace algunos años sufrió un hematoma en el muslo izquierdo, en relación a un traumatismo, que requirió manejo hospitalizado. Se solicitan exámenes que muestran hemograma con 160.000 plaquetas por mm3, sin alteraciones de la serie roja ni blanca, TTPA de 45 segundos y TP de 100%. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Enfermedad de Glanzmann
B Enfermedad de von Willebrand
C Déficit de factor VII
D Hemofilia
E Púrpura trombopénica inmune

Respuesta B. Petequias y equimosis (hemostasia primaria) con plaquetas normales, sangrado tras exodoncia y TTPA levemente prolongado: von Willebrand, que falla en la hemostasia primaria y además baja el factor VIII. La hemofilia no da petequias y tendría hemartrosis; el déficit de VII alarga el TP; Glanzmann no alarga el TTPA; la PTI tiene plaquetas bajas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 22

Una paciente de 17 años, que desde los cinco años presenta epistaxis con frecuencia y equimosis ante pequeños traumatismos, desde los 14 años tiene su menarquia con sangrado menstrual abundantes. Se solicita hemograma que muestra hematocrito 45%, VCM: 90fl, leucocitos 6.000/mm3, plaquetas 250.000/mm3, TTPA normal, protrombinemia 85% y tiempo de sangría mayor a 8 minutos. **¿Cuál es el examen de elección para proseguir con el estudio en este caso?**

A Mielograma
B Citometría de flujo para receptor de la glicoproteína IIb IIIa
C Estudio de enfermedad de Von Willebrand
D Niveles plasmáticos de factor VIII y factor IX de la coagulación
E Electroforesis de proteínas en sangre

Respuesta C. Mujer con sangrado mucocutáneo desde la infancia y menorragia desde la menarquia, plaquetas normales, TTPA normal y tiempo de sangría prolongado (falla de la hemostasia primaria): la causa hereditaria más frecuente es el von Willebrand, y se pide su perfil. Un TTPA normal no lo descarta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 14

Un joven de 18 años presenta sangrado prolongado, luego de la extracción de un molar. Además refiere equimosis ante pequeños traumatismos y epistaxis frecuente. Hace unos años estuvo hospitalizado por un hematoma profundo del muslo derecho. Su hemograma es normal y su TTPA está levementa alargado, con protrombinemia de 80%. El diagnóstico más probable es:

A Enfermedad de Von Willebrand
B Púrpura trombopénico inmune
C Enfermedad de Glanzmann
D Hemofilia
E Factor V de Leiden

Respuesta A. Pregunta muy difícil, porque tanto la hemofilia como la EvW producen epistaxis, equimosis y alveolorragia (epistaxis y alveolorragia son más de EvW). El alargamiento leve del TTPA también puede verse en ambos, aunque la palabra “leve” orienta más a EvW. El hematoma profundo orienta más a hemofilia y es el dato más fuerte como para elegirla, pero la EvW puede tenr hematomas y tipo 3 se caracteriza por tenerlos. Un caso como este está límite entre ambas. La hemofilia probablemente sería más...

▶ VER CLASE **1.08.1.007** **Disproteinemias (gammapatías M)** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.19 · Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar mieloma en adulto mayor (mediana 65–70 años) con dolor óseo, anemia normocítica, falla renal, hipercalcemia y VHS >100 mm/h con Rouleaux en el frotis.
- Criterios CRAB (daño de órgano): calcio >11 mg/dL, creatinina >2 mg/dL o clearance <40, Hb <10 g/dL, lesiones líticas en sacabocado (cráneo, pelvis, columna).
- Estudio: electroforesis de proteínas (pico monoclonal angosto en gamma) e inmunofijación; si es normal con alta sospecha, cadenas ligeras libres y orina de 24 h. Confirma: plasmocitos ≥10 % en médula.
- GMSI: componente M <3 g/dL, plasmocitos <10 % y sin CRAB → solo observar con control anual. Con un criterio CRAB es mieloma activo: tratar.
- Manejo inicial: hidratar con suero fisiológico (calcio y riñón), suspender AINE y derivar a hematología (GES mieloma múltiple). Inducción del especialista: bortezomib + lenalidomida + dexametasona, ± trasplante autólogo.
- Seguimiento: derivar; la GMSI la puede controlar el médico general con electroforesis anual.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 145

Un paciente de 65 años, con cuadro de compromiso del estado general de tres meses de evolución asociado a nicturia y en las últimas semanas dolor lumbar. Al examen físico destaca paciente enflaquecido, piel seca y mucosas pálidas. Se solicitan exámenes de orina que muestra proteinuria ++, urocultivo negativo, 2-3 glóbulos rojos por campo, creatinina 1,8 mg/dL y antígeno prostático de 5,5 (VN <4). Además se realiza ecografía renal que muestra dos quistes renales en lado derecho, sin otros hallazgos. **El diagnóstico más probable en este caso es:**

A Mieloma múltiple
B Cáncer prostático metastásico
C Cáncer renal metastásico
D Espondilodiscitis crónica
E Espondilolistesis

Respuesta A. Adulto mayor con compromiso del estado general, palidez (anemia), proteinuria con falla renal y dolor lumbar (hueso): mieloma múltiple. El antígeno prostático levemente elevado y los quistes renales simples son distractores.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 37

Un paciente de 64 años consulta por dolores óseos. Se realiza un hemograma que muestra hematocrito: 24%, con hemoglobina: 8 g/dl, VCM: 85 fl, plaquetas: 180.000 por mm3 y blancos: 5.800 por mm3, con VHS: 90 mm/h. En los otros exámenes, destaca hipogamaglobulinemia y en el análisis de proteínas séricas se objetiva elevación monoclonal de proteínas, en la zona Kappa. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Macroglobulinemia de Waldeström
B Gamapatía monoclonal incierta
C Mieloma múltiple
D Amiloidosis
E Enfermedad por cadenas pesadas

Respuesta C. Dolor óseo, anemia (Hb 8), VHS elevada y proteína monoclonal de cadenas ligeras kappa: mieloma múltiple (de cadenas ligeras). No es una GMSI, porque hay daño de órgano (anemia bajo 10 y dolor óseo).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años con dolor lumbar mecánico progresivo de 3 meses que no cede con paracetamol ni AINE, y astenia. Palidez y dolor a la palpación vertebral L2-L3, sin fiebre. Hb 8,9 g/dL, VCM 87 fL, VHS 125 mm/h, creatinina 2,6 mg/dL, calcio 11,8 mg/dL (VN 8,5–10,5). Frotis con marcado fenómeno de Rouleaux. Radiografía de cráneo: múltiples lesiones osteolíticas redondeadas, de bordes nítidos, sin esclerosis. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Control ambulatorio anual con electroforesis de proteínas
B Hospitalizar, hidratar con suero fisiológico EV, suspender AINE y derivar urgente a hematología
C Aumentar la dosis de AINE y solicitar resonancia de columna ambulatoria
D Solicitar antígeno prostático y cintigrafía ósea
E Iniciar hierro endovenoso por la anemia

Respuesta B. Mieloma múltiple activo con los cuatro criterios CRAB: calcio 11,8, creatinina 2,6, Hb 8,9 y lesiones líticas en sacabocado. Se hospitaliza, se hidrata con suero fisiológico para tratar la hipercalcemia y proteger el riñón, se suspenden los AINE, se solicita electroforesis e inmunofijación y se deriva urgente a hematología (GES 72) para estudio medular e inducción.

▶ VER CLASE 1.08.1.008 Hipofunción medular

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.5 · Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar aplasia medular ante pancitopenia sin esplenomegalia, hepatomegalia ni adenopatías: síndrome anémico, infecciones graves y púrpura mucocutáneo.
- Causa más frecuente: autoinmune idiopática (linfocitos T). Buscar fármacos (cloranfenicol, tiamazol/PTU, carbamazepina, sulfas, quimioterapia), benceno, radiación, virus (hepatitis, VEB, parvovirus B19).
- Pancitopenia con bazo palpable no es aplasia: cirrosis con hiperesplenismo, leucemia, mielofibrosis, linfoma.
- Confirmación (especialista): biopsia de médula ósea con celularidad <25 % y reemplazo graso. Grave (Camitta, 2 de 3): neutrófilos <500, plaquetas <20.000, reticulocitos <20.000/µL; muy grave: neutrófilos <200.

- Manejo inicial: suspender todo fármaco mielotóxico, prevenir infecciones (nada IM), tratar neutropenia febril con antibiótico EV, transfusión restrictiva con productos desleucocitados e irradiados.
- Seguimiento: derivación inmediata a hematología; definitivo: trasplante alogénico en jóvenes con hermano HLA idéntico o globulina antitimocito + ciclosporina.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

El mejor tratamiento en la aplasia medular idiopática es: **Seleccione la alternativa correcta.**

A Trasplante de médula ósea
B Quimioterapia combinada
C Radioterapia
D Cloranfenicol
E No tiene tratamiento

Respuesta A. El trasplante alogénico de médula ósea, idealmente de un hermano HLA idéntico, es el tratamiento curativo de elección, sobre todo en jóvenes. Si no hay donante o el paciente es mayor, se usa inmunosupresión con globulina antitimocito y ciclosporina. La quimioterapia y la radioterapia dañan más la médula, y el cloranfenicol es una causa de aplasia.

▶ VER CLASE 1.08.1.009 Leucemias agudas

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.16 · Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante insuficiencia medular en semanas: síndrome anémico + fiebre/infecciones + sangrado mucocutáneo; dolor óseo nocturno y hepatoesplenomegalia/adenopatías en el niño (LLA), hiperplasia gingival en LMA monocítica.
- Hemograma con frotis: leucocitosis o leucopenia con blastos. Trombocitopenia aislada no es leucemia (pensar PTI).
- Confirmación (especialista): mielograma con ≥20 % de blastos, citometría de flujo y citogenética. Bastones de Auer = LMA; TdT+ = LLA.
- LLA: neoplasia más frecuente del niño (pico 2–5 años), GES en menores de 15, curación >85 % con protocolo PINDA y profilaxis intratecal. LMA: adulto mayor, inducción 7+3.
- Leucemia promielocítica (M3): blastos con abundantes Auer + CID con fibrinógeno bajo → ATRA inmediato sin esperar PCR, con crioprecipitado y plaquetas. Prevenir lisis tumoral al iniciar quimioterapia.
- Manejo inicial: soporte transfusional, antibiótico EV si hay fiebre y derivación urgente a centro terciario; seguimiento por hematología.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 118

Paciente de 25 años, presenta desde hace 3 semanas compromiso del estado general, sensación febril cuantificada hasta 38°C, asociado a astenia y tendencia a presentar equimosis frente a pequeños traumatismos. Al examen físico se aprecia pálida, se palpa esplenomegalia y se observan abundantes petequias en abdomen y extremidades inferiores asociadas a equimosis en extremidades inferiores. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Leucemia aguda
B Mononucleosis infecciosa
C Linfoma
D Síndrome hemolítico uremico
E Coagulación intravascular diseminada

Respuesta A. Tres semanas de fiebre, astenia y palidez, con petequias y equimosis: anemia, fiebre y sangrado a la vez, es decir, insuficiencia medular aguda. La esplenomegalia refleja infiltración. Es una leucemia aguda clásica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 154

Paciente femenina, de 17 años presenta astenia, decaimiento, dolores óseos y pérdida de peso, de 2 meses evolución. Al examen físico se constatan múltiples adenopatías cervicales y axilares, con bazo palpable 3 cm debajo del reborde costal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Linfoma de Hodgkin
B Leucemia mieloide aguda
C Leucemia linfática aguda
D Síndrome mononucleósico
E Leucemia linfática crónica

Respuesta C. Clínica de leucemia aguda con dolores óseos, adenopatías y esplenomegalia en una paciente joven: orienta a leucemia linfoblástica aguda. La clínica sola no separa con certeza LMA de LLA, pero la edad y la infiltración ganglionar la inclinan hacia la LLA.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 24 años con 2 semanas de astenia severa, fiebre de 38,3 °C, gingivorragia profusa y equimosis. Palidez y petequias, sin adenopatías ni visceromegalias. Hb 6,9 g/dL, leucocitos 32.000/µL con 65% de blastos grandes con gránulos y múltiples bastones de Auer, plaquetas 16.000/µL. INR 1,8, TTPK 45 s, fibrinógeno 85 mg/dL, dímero D > 15.000 ng/mL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Esperar el resultado de PCR para t(15;17) antes de iniciar tratamiento

B Iniciar ATRA de inmediato, con crioprecipitado y plaquetas como soporte

C Iniciar heparina no fraccionada por la CID

D Quimioterapia intratecal con metotrexato

E Plasmaféresis urgente

Respuesta B. Insuficiencia medular con blastos con múltiples bastones de Auer y CID (fibrinógeno bajo, dímero D alto): sospecha de leucemia promielocítica aguda. Se inicia ATRA de inmediato, sin esperar la citogenética, con soporte: crioprecipitado para el fibrinógeno y plaquetas. La heparina empeora el sangrado; la intratecal es de la LLA.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 67

Un paciente de 86 años acude a control por astenia y malestar general de 2 meses de evolución, asociado a bradipsiquia en el último tiempo. Al examen físico, se aprecia palidez de piel y mucosas y se constatan signos vitales con FC: 110x', PA: 126/76 mmHg, sin alteraciones en el examen cardiopulmonar. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma, con hematocrito 16%, hemoglobina: 5,3 g/dl, VCM: 126 ft, glóbulos blancos: 3.300 por mm3, plaquetas: 108.000 por mm3, bilirrubina: 3,6 mg/dl, con fracción directa de 0,6 mg/dl, LDH: 1.012 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Mielodisplasia

B Mieloma múltiple

C Anemia hemolítica

D Anemia megaloblástica

E Leucemia mieloide aguda

Respuesta E. Diagnóstico: Leucemia mieloide aguda (opción E). La vejiga neurogénica es la pérdida de la función vesical normal por denervación, lo que impide que la vejiga se contraiga adecuadamente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 134

Un paciente de 70 años, desde hace 2 semanas ha presentado marcado malestar general y astenia, notando aparición de equimosis en las piernas. En su examen físico, se aprecia pálido, con petequias generalizadas y equimosis. Además, se palpan adenopatías en cuello e ingle. Se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 8,1 g/dl, hematocrito: 24%, glóbulos blancos: 45.000 por mm3, con 60% de blastos linfoides. Su otros exámenes muestran glicemia: 160 mg/dl, Na+: 136 mEq/L, K+: 6,3 mEq/L, ácido úrico: 12,2 mg/dl, fósforo: 7,1 mg/dl, creatinina: 1,3 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Imipenem

B Heparina

C Hidrocortisona

D Sulfonato de poliestireno

E Quimioterapia

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Quimioterapia (opción E).

▶ VER CLASE 1.08.1.010 **Leucemias crónicas** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.17 · Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)

QUÉ HAY QUE SABER

- LMC: adulto 40–60 años con leucocitosis marcada (50.000–300.000) con toda la serie granulocítica, basofilia, plaquetas normales o altas y esplenomegalia (puede ser gigante).
- LMC se confirma con cromosoma Filadelfia t(9;22) / BCR-ABL1; tratamiento de elección imatinib u otro ITK oral (GES), con expectativa de vida casi normal. Fases: crónica, acelerada y crisis blástica (≥20 % blastos).
- LLC: adulto mayor (>70 años) con linfocitosis B madura ≥5.000/µL por ≥3 meses, sombras de Gümprecht, adenopatías indoloras; confirma citometría (CD19, CD5, CD23).
- LLC temprana (Binet A, sin citopenias) asintomática: observar; tratar solo si Hb <10, plaquetas <100.000 o síntomas (ibrutinib, venetoclax).
- Complicaciones de LLC: hipogammaglobulinemia con infecciones, AHAI caliente y PTI; crecimiento rápido de un ganglio sugiere síndrome de Richter.
- Diferenciar de reacción leucemoide (infección grave, fosfatasa alcalina leucocitaria alta, sin basofilia ni Filadelfia). Seguimiento: derivar a hematología.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 12

Un paciente de 81 años, en espera de una cirugía de cataratas, se realiza un hemograma, como parte de los exámenes preoperatorios, que muestra 140.000 blancos, con predominio de linfocitos, de aspecto redondo, con citoplasma escaso, cromatina heterogénea y sombras de Gumprecht, además tiene hemoglobina de 13,1 g/dl y 180.000 plaquetas por mm3. Al examen físico se palpa una adenopatía cervical de 3 cm, indolora. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Leucemia aguda
B Mielodisplasia
C Leucemia mieloide crónica
D Linfoma
E Leucemia linfática crónica

Respuesta E. Adulto mayor asintomático, hallazgo en exámenes preoperatorios, linfocitosis madura con sombras de Gumprecht y adenopatía indolora: leucemia linfática crónica. El linfoma no explica una linfocitosis de 140.000; la LMC tendría toda la serie granulocítica y esplenomegalia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 164

Una paciente de 83 años se realiza exámenes preoperatorios, por una cirugía de cataratas, entre los que destaca un hemograma con 86.000 glóbulos blancos por mm3, hematocrito: 32%, hemoglobina: 11 g/dl, plaquetas: 123.000 por mm3. La fórmula diferencial muestra 86% de linfocitos, con aumento de citoplasma y sombras de Gumprecht en el frotis. Al examen físico se palpan múltiples adenopatías gomosas, generalizadas, de 2 a 3 cm de diámetro. **El diagnóstico más probable es:**

A Leucemia mieloide crónica en crisis blástica
B Linfoma
C Leucemia linfática crónica clásica
D Leucemia mieloide crónica estable
E Leucemia de células velludas

Respuesta C. Adulta mayor con linfocitosis madura, sombras de Gumprecht y adenopatías generalizadas: LLC clásica. Las citopenias leves pueden acompañarla. El linfoma suele tener hemograma normal; la LMC tiene predominio granulocítico con desviación izquierda, basofilia y trombocitosis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 108

Un paciente de 65 años, diabético, presenta un cuadro de astenia y sensación febril de 4 semanas de evolución, asociado a baja de peso de 3 kilogramos, no explicado. Además, refiere dolor abdominal epigástrico y en el hipocondrio izquierdo. Al examen físico tiene ligera palidez de mucosas y se palpa el bazo por 13 cm bajo el reborde costal. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 32%, hemoglobina: 10,6 g/dl, VCM: 90 fl, blancos: 65.000 por mm3, con 15% de juveniles, 20% mielocitos, 13% promielocitos y 5% de blastos, con plaquetas: 450.000 por mm3. **El diagnóstico más probable es:**

A Leucemia mieloide aguda
B Leucemia linfática crónica
C Leucemia mieloide crónica
D Mielodisplasia
E Mielofibrosis

Respuesta C. Esplenomegalia gigante, leucocitosis con toda la serie granulocítica (sin hiato leucémico), solo 5% de blastos y trombocitosis: LMC en fase crónica. La LMA tendría 20% o más de blastos, hiato leucémico y plaquetas bajas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 76 años, autovalente, en control de hipertensión. Asintomático. Ganglios cervicales e inguinales bilaterales de 1 cm, móviles e indoloros; sin esplenomegalia. Hb 13,8 g/dL, plaquetas 195.000/µL, leucocitos 42.000/µL con 88% de linfocitos maduros. Frotis con sombras de Gümprecht. Citometría: población B clonal CD19+, CD5+, CD23+. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Observación clínica periódica cada 3 a 6 meses, sin tratamiento
B Iniciar imatinib oral
C Iniciar ibrutinib de inmediato
D Quimioterapia de inducción tipo 7 + 3
E Biopsia ganglionar urgente por sospecha de linfoma

Respuesta A. LLC confirmada por citometría, en estadio temprano (Binet A: menos de 3 áreas ganglionares, sin anemia ni plaquetopenia) y asintomática. El tratamiento precoz no prolonga la sobrevida: la conducta es observar ("watch and wait"). Imatinib es de la LMC; ibrutinib se reserva para enfermedad avanzada o sintomática.

▶ VER CLASE **1.08.1.011** **Linfomas** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.18 · Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante adenopatía indolora, gomosa, >2 cm y persistente >4–6 semanas sin foco infeccioso; supraclavicular es neoplásica hasta demostrar lo contrario.
- Síntomas B: fiebre >38 °C inexplicada, sudoración nocturna y baja de peso >10 % en 6 meses; prurito y dolor con alcohol orientan a Hodgkin pero no son B.
- Diagnóstico: biopsia escisional del ganglio completo (o trucut si es profundo); la PAAF no sirve porque no muestra la arquitectura.

- Hodgkin: bimodal (15–35 y >60 años), Reed-Sternberg CD30+/CD15+, diseminación por contigüidad, masa mediastínica en esclerosis nodular; ABVD cura >85 % (GES). No Hodgkin: adulto mayor, diseminación hematógena y extraganglionar; LDCBG con R-CHOP; folicular indolente se observa.
- Etapificación Ann Arbor: I una región; II dos o más del mismo lado del diafragma; III ambos lados; IV extralinfático diseminado. MALT gástrico temprano: erradicar H. pylori.
- Manejo inicial: no tratar sin histología, derivar para biopsia y etapificación; seguimiento por hematología.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 106

Una paciente de 20 años consulta por aumento de volumen en el cuello de 2 meses de evolución, asociado a leve malestar general, fiebre ocasional y sudoración nocturna. Al examen físico, se palpan adenopatías submandibulares y cervicales bilaterales de consistencia aumentada. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Tuberculosis ganglionar

B Linfoma

C Infección por VIH

D Sarcoidosis

E Mononucleosis infecciosa

Respuesta B. Mujer joven con adenopatías cervicales duras de 2 meses, fiebre y sudoración nocturna: linfoma, probablemente de Hodgkin por la edad. El diagnóstico definitivo se hace con biopsia ganglionar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 4

Una paciente de 22 años presenta un cuadro de fiebre nocturna, asociada a baja de peso de 3 meses de evolución y astenia. Además refiere aumento de volumen cervical. Al examen físico se aprecia palidez de piel y mucosas y una masa de 6 cm de diámetro en la cara lateral derecha del cuello. En la radiografía de tórax, se constata ensanchamiento del mediastino. **El diagnóstico más probable es:**

A Leucemia linfática crónica

B Infección por VIH

C Tuberculosis ganglionar

D Linfoma de Hodgkin

E Linfoma no Hodgkin

Respuesta D. Mujer joven con síntomas B, masa cervical y ensanchamiento mediastínico: linfoma de Hodgkin, probablemente esclerosis nodular (mujer joven, mediastino anterior). La edad orienta a Hodgkin por sobre no Hodgkin; la LLC es del adulto mayor.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 140

Un paciente de 15 años consulta por tos de 7 días de evolución asociada a cefalea y malestar general, que en los últimos días ha evolucionado con empeoramiento de los síntomas, dificultad respiratoria y edema de la cara. Al examen físico se observa agitado, con eritema facial, edema de párpados y lengua de mayor tamaño que lo normal. Se aprecian yugulares visibles en el cuello y se palpan adenopatías cervicales múltiples, de hasta 2 cm de diámetro. Se solicita radiografía de tórax que muestra presencia de una masa mediastínica. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Linfoma de Hodgkin

B Carcinoma broncogénico

C Cáncer de tiroides

D Tuberculosis

E Timoma

Respuesta A. Edema facial, yugulares ingurgitadas y masa mediastínica: síndrome de vena cava superior. En un adolescente con adenopatías cervicales, la causa más probable es un linfoma de Hodgkin con compromiso mediastínico. En un adulto mayor fumador sería más probable el carcinoma broncogénico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 102

Un paciente de 55 años presenta un cuadro de 3 meses de evolución de astenia y baja de peso de 5 kg, a lo que se ha agregado sudoración en la noche y fiebre intermitente hasta 38,5 °C que ha manejado con paracetamol. Al examen físico está hemodinámicamente estable, con signos vitales dentro de rango normal, y se palpan adenopatías cervicales de consistencia gomosa en ambos lados de la zona anterior del cuello. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 37%, hemoglobina: 12,2 g/dL, glóbulos blancos: 5.600/mm³ y plaquetas: 160.000/mm³. Se solicita radiografía de tórax que muestra múltiples adenopatías mediastínicas y TAC de abdomen y pelvis que muestra presencia de múltiples adenopatías retroperitoneales. **¿Cuál es el examen de elección para determinar el diagnóstico en este caso?**

A Biopsia de médula ósea

B Serología para virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y VIH

C Biopsia aspirativa de la adenopatía

D Biopsia ganglionar excisional

E Hemocultivos

Respuesta D. Adenopatías gomosas cervicales, mediastínicas y retroperitoneales con síntomas B: linfoma (por la edad, probablemente no Hodgkin). El diagnóstico se hace con biopsia ganglionar excisional; la aspirativa no muestra la arquitectura. El hemograma casi normal no descarta linfoma.

▶ VER CLASE **1.08.1.012** **Púrpuras trombopénicos** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Hematología 8.10 · Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU
Hematología 8.12 · Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES

QUÉ HAY QUE SABER

- PTI: trombocitopenia aislada con examen físico normal salvo púrpura mucocutáneo; sin esplenomegalia, adenopatías ni fiebre (si las hay, buscar leucemia o linfoma).
- Primer paso: frotis o recuento en citrato para descartar pseudotrombocitopenia por EDTA. En adulto buscar causa secundaria: LES, VIH, VHC, H. pylori.
- Niño 2–6 años post virosis: aguda, remite sola en >80 % (observar). Adulto (mujer joven): insidiosa, crónica en >70 %.
- Tratar si plaquetas <20.000–30.000/µL o sangrado mucoso: prednisona 1 mg/kg/día o dexametasona 40 mg/día por 4 días. Sangrado grave: IgEV 1 g/kg/día; plaquetas solo con riesgo vital (hemorragia intracraneana).
- Esquistocitos con plaquetopenia y coagulación normal: microangiopatía trombótica (PTT en adulto con neurología, SHU en niño con diarrea y falla renal): plasmaféresis urgente en PTT y nunca transfundir plaquetas.
- Seguimiento: derivar a hematología; segunda línea agonistas de trombopoyetina, rituximab o esplenectomía (tras 12 meses y vacunas).

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 131

Un paciente de 24 años presenta un cuadro de cefalea y desorientación, asociado a malestar general e ictericia. Al examen físico tiene ictericia de piel y escleras, PA: 160/100 mmHg, se palpa edema de ambas extremidades inferiores. Se solicitan exámenes, entre los que destacan bilirrubina total: 12 mg/dl, LDH: 2.100 UI/L, creatinina: 3,5 mg/dl, hemoglobina: 7,0 g/dl, hematocrito: 22%, plaquetas: 50.000/mm3, blancos: 8.000/mm3, frotis con esquistocitos, poiquilocitos, anisocitosis y disminución de las plaquetas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Púrpura inmune trombocitopénica
B Síndrome de Evans
C Anemia hemolítica autoinmune
D Púrpura trombótico trombocitopénico
E Lupus eritematoso sistémico

Respuesta D. PTT clásico: trombocitopenia, anemia hemolítica (LDH alta, esquistocitos, bilirrubina indirecta), falla renal y compromiso neurológico. El síndrome de Evans es anemia hemolítica autoinmune más trombocitopenia autoinmune, sin esquistocitos ni falla renal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 75

Niño de 6 años previamente sano, sin medicamentos, consulta por púrpura petequial generalizada de inicio súbito posterior a infección viral. Plaquetas: 10.000/mm³. Resto del hemograma normal. Sin adenopatías ni visceromegalias. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Púrpura trombocitopénica inmune (PTI)
B Púrpura trombótica trombocitopénica
C Síndrome hemolítico urémico
D Coagulación intravascular diseminada
E Leucemia aguda linfoide

Respuesta A. Niño sano, inicio súbito tras una virosis, trombocitopenia aislada y examen físico normal: PTI. Sin anemia hemolítica ni falla renal (no es PTT ni SHU) y sin otras series alteradas ni visceromegalias (no es leucemia).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 121

Adulto con PTI sin sangrado grave, plaquetas en 5.000: **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Corticoides 1mg/kg
B Transfusión de plaquetas
C Terapia biológica
D Amoxicilina
E Ibuprofeno

Respuesta A. PTI del adulto con plaquetas muy bajas, sin sangrado grave: primera línea con corticoides (prednisona 1 mg/kg/día). La transfusión de plaquetas se reserva para el sangrado con riesgo vital; la terapia biológica es de segunda línea.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 36 años, previamente sana, con 24 horas de desorientación fluctuante y cefalea. Febril (38,1 °C), confusa, con petequias diseminadas, sin focalidad motora. Hb 7,2 g/dL, plaquetas 18.000/µL, LDH 1.450 UI/L, bilirrubina indirecta 3,6 mg/dL, creatinina 1,6 mg/dL. TP 12 s (100 %), TTPK 31 s, fibrinógeno 320 mg/dL. Frotis: esquistocitos 3,5 %. Coombs directo negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Transfundir concentrado de plaquetas y observar

B Plasmaféresis urgente en UCI y corticoides en dosis altas

C Plasma fresco y crioprecipitado, y buscar foco séptico

D Hemodiálisis de urgencia

E Inmunoglobulina endovenosa como en la PTI

Respuesta B. Trombocitopenia grave, anemia hemolítica con esquistocitos y Coombs negativo, síntomas neurológicos fluctuantes, fiebre y compromiso renal leve, con coagulación normal: PTT. Plasmaféresis urgente en UCI y corticoides. Transfundir plaquetas está contraindicado; la coagulación normal descarta CID.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 28 años, sana, consulta por 3 semanas de petequias en las piernas y equimosis pequeñas. Sin epistaxis, gingivorragia ni metrorragia. Examen físico: petequias en extremidades inferiores, sin adenopatías, bazo no palpable. Hb 13 g/dL, leucocitos normales, plaquetas 14.000/µL. TP y TTPK normales. Frotis: trombocitopenia real, sin esquistocitos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Observación ambulatoria y evitar AINE

B Transfusión de concentrado de plaquetas

C Prednisona 1 mg/kg/día

D Esplenectomía laparoscópica

E Plasmaféresis urgente

Respuesta C. PTI del adulto con plaquetas bajo 20.000–30.000/µL: se trata aunque no haya sangrado mucoso. Primera línea: prednisona 1 mg/kg/día (o dexametasona 40 mg/día por 4 días). La observación es para más de 30.000/µL; la transfusión, solo para el riesgo vital; la esplenectomía, para el refractario después de 12 meses; la plasmaféresis, para el PTT.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 131

Paciente hospitalizado en anticoagulación con heparina no fraccionada. Exámenes: TP 14s (normal), TTPA 120s (normal 25-35s), plaquetas 45.000/mm³ (bajaron de 180.000 hace 5 días). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trombocitopenia inducida por heparina (HIT) tipo II

B CID

C PTT

D Trombocitopenia por sepsis

E Efecto del anticoagulante sobre el conteo plaquetario

Respuesta A. Caída de plaquetas >50% a los 5-10 días de inicio de heparina = HIT tipo II (mediada por anticuerpos anti-PF4/heparina). Suspender heparina inmediatamente y cambiar a anticoagulación alternativa (argatrobán).

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 107

48 horas y que ha evolucionado con deterioro del estado general y desorientación. Al examen físico tiene ictericia de piel y escleras, PA: 160/100 mmHg, presencia de múltiples petequias y algunas equimosis en las extremidades inferiores, con edema bimaleolar. Se solicitan exámenes, entre los que destacan bilirrubina total: 12 mg/dl, LDH: 2.100 Ul/L, creatinina: 3,5 mg/dl, hemoglobina: 10 g/dl, hematocrito: 29%, plaquetas: 70.000/mma3, blancos: 8.000/mma3, frotis con esquistocitos, poiquilocitos y anisocitosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Púrpura trombocitopénica inmune

B Síndrome de Evans

C Anemia hemolítica autoinmune

D Púrpura trombocitopénico trombótico

E Lupus eritematoso sistémico

Respuesta D. Tiene una PTT clásica, con la trombopenia, anemia hemolítica, falla renal (igual al SHU) y afectación neurológica tanto central como periférica.

▶ VER CLASE 1.08.1.013 **Púrpuras vasculares** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.22 · Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

QUÉ HAY QUE SABER

- Púrpura vascular: púrpura palpable con recuento plaquetario normal (diferencia clave con PTI y meningococcemia) por vasculitis de pequeño vaso.
- Púrpura de Schönlein-Henoch (vasculitis IgA): niño con púrpura palpable en extremidades inferiores y nalgas, artralgias/artritis de rodillas y tobillos, dolor abdominal cólico (riesgo de invaginación) y nefritis por IgA.
- Manejo inicial de Henoch: reposo, paracetamol; prednisona 1 mg/kg/día por una semana si hay dolor abdominal severo. Curso habitualmente autolimitado.
- Vasculitis leucocitoclástica por fármacos: suspender el fármaco y confirmar con biopsia de piel.
- Sospechar vasculitis ANCA si hay compromiso sistémico: GPA (c-ANCA, sinusitis, nariz en silla de montar, nódulos cavitados), PAM (p-ANCA, síndrome riñón-pulmón), EGPA (asma, eosinofilia).

- Seguimiento: en Henoch controlar orina y presión arterial por 6 meses; derivar ante nefritis, compromiso sistémico o sospecha de vasculitis ANCA.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 6 años, con infección respiratoria alta hace 2 semanas, presenta lesiones purpúricas palpables en glúteos y extremidades inferiores, dolor abdominal cólico y artralgias de tobillos. Plaquetas 320.000/mm3 y pruebas de coagulación normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Púrpura trombocitopénica inmune
B Meningococcemia
C Leucemia linfoblástica aguda
D Púrpura de Schönlein-Henoch (vasculitis por IgA)
E Hemofilia A

Respuesta D. Púrpura palpable con plaquetas y coagulación normales indica una púrpura vascular. En un niño, con distribución en glúteos y piernas, dolor abdominal y artralgias, corresponde a vasculitis por IgA (Schönlein-Henoch). Deben controlarse orina y presión arterial por riesgo de nefritis. La PTI cursa con plaquetopenia y púrpura no palpable.

▶ VER CLASE 1.08.1.014 Reacción leucemoide

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.17 · Leucemias Crónicas: Leucemia Mieloide Crónica (LMC, BCR-ABL) vs Leucemia Linfática Crónica (LLC)

QUÉ HAY QUE SABER

- Reacción leucemoide: leucocitosis reactiva >50.000/µL con desviación a izquierda (baciliformes, mielocitos), secundaria a infección grave, inflamación, hemorragia o neoplasia.
- Hallazgos a favor: fosfatasa alcalina leucocitaria elevada, granulaciones tóxicas, sin basofilia, sin blastos y sin esplenomegalia.
- Diferencial con LMC: esta tiene basofilia, esplenomegalia, fosfatasa alcalina leucocitaria baja y cromosoma Filadelfia / BCR-ABL positivo.
- Manejo inicial: buscar y tratar la causa (foco infeccioso, enfermedad inflamatoria o tumoral); la leucocitosis se resuelve al tratarla.
- Seguimiento: derivar a hematología si la leucocitosis persiste sin causa clara, hay blastos, basofilia o esplenomegalia (estudio de BCR-ABL).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 65 años hospitalizado por neumonía grave presenta leucocitos de 58.000/mm3 con neutrofilia y desviación a izquierda, con baciliformes y algunos mielocitos, sin blastos ni basofilia. No tiene esplenomegalia. **¿Cuál hallazgo apoya más una reacción leucemoide en lugar de una leucemia mieloide crónica?**

A Fosfatasa alcalina leucocitaria elevada
B Presencia de cromosoma Filadelfia
C Basofilia marcada
D Esplenomegalia masiva
E Gen de fusión BCR-ABL positivo

Respuesta A. La reacción leucemoide es una leucocitosis reactiva mayor de 50.000 con desviación a izquierda, secundaria a infección grave, inflamación o neoplasia, que se resuelve al tratar la causa. Cursa con fosfatasa alcalina leucocitaria elevada y granulaciones tóxicas. La LMC tiene fosfatasa baja, basofilia, esplenomegalia y BCR-ABL (cromosoma Filadelfia) positivo.

▶ VER CLASE 1.08.1.015 Síndrome leucoeritroblástico

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.20 · Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome leucoeritroblástico: precursores eritroides (eritroblastos) y mieloides inmaduros (mielocitos, metamielocitos) en sangre periférica, con dacriocitos (glóbulos rojos en lágrima).
- Indica ocupación o fibrosis de la médula ósea: metástasis óseas (mama, próstata, pulmón), mielofibrosis primaria, linfomas, leucemias o tuberculosis.
- Sospechar en paciente con antecedente neoplásico, dolor óseo y citopenias; mielofibrosis: esplenomegalia masiva, dacriocitos y aspirado seco.
- Estudio: biopsia de médula ósea (el aspirado puede ser seco) e imágenes para buscar el tumor primario o metástasis.
- Manejo inicial: soporte de las citopenias y derivar a hematología u oncología según la causa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 63 años con antecedente de cáncer de mama tratado hace 5 años consulta por dolor óseo y fatiga. Hemoglobina 8,9 g/dL, plaquetas 95.000/mm3. El frotis muestra eritroblastos circulantes, mielocitos y metamielocitos, y dacriocitos (glóbulos rojos en lágrima). **¿Cuál es la interpretación más adecuada del frotis?**

A Anemia ferropénica por pérdida digestiva

B Anemia por déficit de vitamina B12

C Anemia hemolítica autoinmune

D Reacción leucemoide por infección

E Síndrome leucoeritroblástico sugerente de infiltración medular

Respuesta E. Precursores eritroides y mieloides inmaduros en sangre periférica, con dacriocitos, constituyen un síndrome leucoeritroblástico, que indica ocupación o fibrosis de la médula ósea. En esta paciente sugiere metástasis óseas de cáncer de mama; otras causas son mielofibrosis, linfomas y tuberculosis. Se estudia con biopsia de médula ósea e imágenes.

▶ VER CLASE 1.08.1.016 Síndrome paraneoplásico

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.2 · Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndromes paraneoplásicos: efectos a distancia del tumor, no por invasión ni metástasis; pueden preceder al diagnóstico del cáncer.
- Cáncer pulmonar microcítico: SIADH (hiponatremia hipotónica), Cushing ectópico por ACTH (hipokalemia, alcalosis metabólica) y Lambert-Eaton (anticuerpos anticanales de calcio).
- Epidermoide: hipercalcemia humoral por PTHrP con PTH suprimida y sin metástasis óseas. Adenocarcinoma: osteoartropatía hipertrófica (acropaquia + periostitis). Células grandes: ginecomastia por beta-HCG.
- Ante un fumador con alguno de estos cuadros: radiografía/TAC de tórax y obtener histología (fibrobroncoscopía o biopsia).
- Manejo inicial: corregir la alteración metabólica (suero fisiológico y zoledronato en hipercalcemia; restricción hídrica en SIADH) y derivar a oncología; el control definitivo es tratar el tumor.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 64 años, fumador de 50 paquetes-año, con masa hiliar central en la radiografía de tórax, presenta náuseas y somnolencia. Sodio 119 mEq/L, osmolalidad plasmática 250 mOsm/kg, osmolalidad urinaria 520 mOsm/kg, sodio urinario 60 mEq/L. Está euvolémico y la función tiroidea y el cortisol son normales. **¿Cuál es el tipo histológico más probablemente asociado?**

A Adenocarcinoma

B Carcinoma escamoso

C Carcinoma de células pequeñas

D Carcinoma de células grandes

E Tumor carcinoide periférico

Respuesta C. Hiponatremia hipotónica euvolémica con orina concentrada y sodio urinario alto es un SIADH, síndrome paraneoplásico clásico del carcinoma pulmonar de células pequeñas, tumor central de fumadores, que también produce ACTH ectópica y síndrome de Lambert-Eaton. El carcinoma escamoso se asocia típicamente a hipercalcemia por PTHrP.

▶ VER CLASE 1.08.1.017 Síndromes mielodisplásicos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.20 · Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en adulto mayor con citopenias refractarias y macrocitosis arregenerativa: médula llena (normo o hipercelular) pero hematopoyesis ineficaz.
- Frotis: displasia, neutrófilos hipogranulares con núcleos bilobulados (pseudo-Pelger-Huët), sin o con pocos blastos.
- Antes de plantearlo descartar déficit de B12 y folato, hipotiroidismo, alcohol y daño hepático.
- Confirmación (especialista): mielograma y biopsia de médula con citogenética, que define el riesgo (IPSS-R).
- Riesgo de evolución a leucemia mieloide aguda. Manejo inicial: soporte transfusional y tratamiento de infecciones; derivar a hematología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 76 años, no bebedor, con astenia y disnea de esfuerzos progresiva de 6 meses. Sin visceromegalias ni adenopatías. Hb 8,6 g/dL, VCM 104 fL, reticulocitos 0,5 %, leucocitos 2.900/µL (RAN 1.200/µL), plaquetas 98.000/µL. Vitamina B12, folato, TSH y pruebas hepáticas normales. Frotis: neutrófilos hipogranulares con núcleos bilobulados (pseudo-Pelger-Huët), sin blastos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Vitamina B12 intramuscular empírica y control en 2 meses

B Coombs directo y haptoglobina

C Electroforesis de proteínas séricas

D Eritropoyetina subcutánea sin más estudio

E Aspirado y biopsia de médula ósea con estudio citogenético

Respuesta E. Adulto mayor con citopenias y macrocitosis arregenerativa, sin déficit de B12 ni folato, hipotiroidismo o daño hepático, y con displasia en el frotis: sospecha de síndrome mielodisplásico. Se confirma con mielograma y biopsia de médula ósea (displasia, porcentaje de blastos) más citogenética, que define el riesgo (IPSS-R) y el tratamiento.

▶ VER CLASE 1.08.1.018 Síndromes mieloproliferativos crónicos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Hematología 8.20 · Neoplasias Mieloproliferativas (Policitemia Vera JAK2, TE, Mielofibrosis) y Mielodisplasia

QUÉ HAY QUE SABER

- Policitemia vera: Hb >16,5 (H) / >16 (M) o Hto >49/48 %, prurito acuagénico tras ducha caliente, facies pletórica, eritromelalgia, esplenomegalia y panmielosis; riesgo principal: trombosis.
- Diferenciar de poliglobulia secundaria (EPOC, apnea, tabaco, altura, cáncer renal): EPO alta y JAK2 negativo; en PV la EPO está suprimida y JAK2 V617F positivo (>95 %). Descartar policitemia relativa por deshidratación.
- Manejo PV: flebotomías hasta Hto <45 % + aspirina 100 mg/día; hidroxiurea si >60 años o trombosis previa. Secundaria: tratar la causa (oxígeno, dejar el tabaco).
- Trombocitemia esencial: plaquetas >450.000/µL sostenidas (JAK2, CALR, MPL); puede trombosar o sangrar paradójicamente.
- Mielofibrosis primaria: esplenomegalia masiva, dacriocitos, leucoeritroblastosis y aspirado seco → biopsia ósea obligatoria.
- LMC también es mieloproliferativo (Filadelfia, imatinib). Seguimiento: derivar a hematología.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 9

Un paciente de 54 años, presenta un cuadro de varias semanas de evolución de astenia, adinamia y disnea que aparecen a los grandes esfuerzos. Al examen físico se aprecia palidez de piel y mucosas, se palpa el hígado 6 cm bajo el reborde costal derecho y el bazo se palpa 10 cm bajo el reborde costal izquierdo. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito de 29% con hemoglobina de 9,6 g/dL, blancos 4.200/mm3, plaquetas 111.000/mm3 y al frotis se aprecia macrocitosis y abundantes dacriocitos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Mieloptisis

B Mieloma multiple

C Leucemia mieloide crónica

D Mielodisplasia

E Mielofibrosis primaria

Respuesta E. Hepatoesplenomegalia marcada (bazo a 10 cm) por hematopoyesis extramedular, citopenias y abundantes dacriocitos en el frotis: mielofibrosis primaria. La mielofibrosis es, en rigor, una forma de mieloptisis (ocupación medular), pero la respuesta más específica es la E.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 56 años, no fumador, sin patología pulmonar, consulta por prurito urente intenso en brazos y tórax que aparece 10 minutos después de ducharse con agua caliente, cefalea y mareos. Rubicundez facial y conjuntival; bazo palpable a 3 cm bajo el reborde costal. Hb 18,9 g/dL, Hto 56%, leucocitos 13.400/µL, plaquetas 490.000/µL. SatO2 98%, PaO2 92 mmHg. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el estudio que corresponde?**

A Poliglobulia secundaria; solicitar espirometría y polisomnografía

B Policitemia vera; solicitar eritropoyetina sérica y mutación JAK2 V617F

C Trombocitemia esencial; solicitar mutación de calreticulina

D Policitemia relativa; hidratar y repetir el hemograma

E Mielofibrosis primaria; solicitar biopsia de médula ósea

Respuesta B. Eritrocitosis absoluta con panmielosis (leucocitosis y trombocitosis), esplenomegalia, prurito acuagénico y facies pletórica, con oxigenación normal: policitemia vera. Se confirma con EPO sérica (suprimida) y mutación JAK2 V617F. Se inician flebotomías hasta Hto < 45% más aspirina 100 mg/día.

▶ VER CLASE 1.08.1.019 Trombofilias

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Hematología 8.23 · Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo

Reumatología 9.11 · Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar trombofilia ante TEV no provocado en menor de 50 años, trombosis recurrentes, en sitios atípicos (senos venosos cerebrales, mesentéricas, suprahepáticas) o antecedente familiar directo de TEV precoz. No estudiar la trombosis provocada.
- Hereditarias: factor V Leiden (la más frecuente), protrombina G20210A, déficit de antitrombina (la más trombogénica, resistencia a heparina), déficit de proteína C o S.
- Síndrome antifosfolípido (la adquirida más frecuente, primaria o con LES): trombosis arterial o venosa o morbilidad obstétrica (≥3 abortos <10 sem, muerte fetal ≥10 sem, parto <34 sem por preeclampsia) + anticuerpos positivos 2 veces separados 12 semanas.
- Anticoagulante lúpico: TTPK prolongado que no corrige con la mezcla, con trombosis y no sangrado.
- Manejo inicial: HBPM con puente a cumarínico (evita necrosis cutánea en déficit de proteína C). SAF: cumarínico INR 2–3 de por vida, DOAC contraindicados; embarazo con SAF: aspirina + enoxaparina.
- Seguimiento: derivar a hematología; proteínas C, S y antitrombina se miden 4–6 semanas sin anticoagulación, el estudio genético en cualquier momento.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 55

Un paciente de 18 años consulta por dolor y aumento de volumen en la pantorrilla izquierda, en relación a un pequeño traumatismo. Se solicita un estudio Doppler de las extremidades inferiores, que muestra alteraciones del drenaje venoso profundo de la zona. En sus exámenes, se constata hematocrito: 38%, hemoglobina: 12,8 g/dl, plaquetas: 145.000 por mm3, blancos: 8.000 por mm3, TTPA 54 segundos, protrombina: 85%. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Déficit de antitrombina III
B Hemofilia A
C Trombofilia por anticoagulante lúpico
D Hemofilia B
E Enfermedad de Von Willebrand

Respuesta C. El Doppler muestra una trombosis venosa profunda, no un hematoma. Trombosis con TTPA alargado y TP normal: anticoagulante lúpico, un inhibidor que alarga el TTPA in vitro pero produce trombosis in vivo. Las hemofilias y el von Willebrand sangran; el déficit de antitrombina no alarga el TTPA.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 54

Un paciente de 32 años, presenta una trombosis venosa profunda femoropoplítea. Como antecedente, su abuelo falleció a los 85 años, por un accidente vascular encefálico y su padre tuvo un infarto agudo al miocardio a los 60 años. En sus exámenes destacan plaquetas: 140.000 por mm3, TTPA prolongado y VDRL (+). **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Déficit de antitrombina III
B Déficit de factor VIII
C Síndrome antifosfolípidos
D Púrpura trombocitopénica trombótica
E Enfermedad de Von Willebrand

Respuesta C. Trombosis en un joven con TTPA prolongado y VDRL positivo: síndrome antifosfolípido. Los anticuerpos antifosfolípidos prolongan el TTPA in vitro y pueden dar un VDRL falsamente positivo. El déficit de antitrombina es una trombofilia, pero no alarga el TTPA; el déficit de factor VIII y el von Willebrand sangran.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2022 · PREGUNTA 11

Hombre de 35 años sin antecedentes mórbidos ingresa por tromboembolismo pulmonar segmentario agudo no masivo. En sus exámenes preoperatorios de hemostasia destaca un tiempo de protrombina (TP) normal y un tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPK) prolongado (68 segundos, control 30 s). La prueba de mezclas con plasma normal no corrige el TTPK, pero este se normaliza completamente al agregar exceso de fosfolípidos a la muestra. ¿Cuál es la explicación biológica de este hallazgo de laboratorio?

A Déficit congénito severo de Factor VIII (Hemofilia A)
B Presencia de Anticoagulante Lúpico circulante
C Contaminación inadvertida de la muestra con heparina no fraccionada
D Presencia de anticuerpos inhibidores específicos del Factor IX
E Déficit severo de Factor de von Willebrand tipo 3

Respuesta B. La prolongación del TTPK que no corrige con plasma normal (descartando déficit de factores de la vía intrínseca) pero que corrige al añadir un exceso de fosfolípidos exógenos demuestra la presencia de un inhibidor dependiente de fosfolípidos, fenómeno patognomónico del Anticoagulante Lúpico. Representa la paradoja del SAF: alarga los tiempos de coagulación in vitro en el laboratorio pero produce trombosis in vivo.

Situaciones clínicas de urgencia

9 códigos

▶ VER CLASE | 1.08.2.001 | **Coagulación intravascular diseminada** | DX SOSPECHA | TX INICIAL | SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.15 · Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- CID: síndrome secundario a sepsis (la más frecuente, gramnegativos), causas obstétricas (desprendimiento de placenta, embolia de líquido amniótico, feto muerto), trauma grave, quemaduras, leucemia promielocítica o neoplasias avanzadas.
- Sospechar ante sangrado por sitios de punción, mucosas y heridas junto con falla multiorgánica por microtrombosis.

- Laboratorio todo alterado a la vez: plaquetas bajas, TP y TTPK prolongados, fibrinógeno <100 mg/dL (en un séptico, 200 ya es consumo) y dímero D muy alto. Score ISTH ≥5 = CID manifiesta.
- Tratamiento inicial: tratar la causa (antibióticos y control del foco, vaciamiento uterino, ATRA en M3).
- Si sangra o requiere procedimiento: crioprecipitado si fibrinógeno <100–150, plasma 15–20 mL/kg si TP/TTPK >1,5 veces, plaquetas meta >50.000 (>20.000 si no sangra). Heparina contraindicada si predomina el sangrado.
- Seguimiento: no requiere seguimiento específico una vez resuelta la causa.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 54

Una mujer puérpera, preseenta hemorragia postparto importante. En sus exámenes destacan hemograma con hematocrito: 28%, hemoglobina: 9,3 g/dl, glóbulos blancos: 8.000 por mm3, plaquetas: 80.000 y además tiene TTPA y TP alargados y fibrinógeno 90 mg/dl (VN: 200 a 400) **¿Cuál es la mejor indicación transfusional?**

A Crioprecipitado
B Glóbulos rojos
C Plaquetas
D Sangre fresca
E Plasma fresco congelado

Respuesta E. Hemorragia posparto con plaquetas bajas, TP y TTPA prolongados y fibrinógeno bajo: CID obstétrica. El plasma fresco congelado aporta todos los factores de la coagulación, incluido el fibrinógeno, y corrige a la vez el TP y el TTPA. El crioprecipitado solo repone fibrinógeno; las plaquetas en 80.000 no son la prioridad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 54

Puérpera con hemorragia postparto importante. Su hemograma muestra hematocrito veintiocho por ciento, plaquetas ochenta mil, con tiempo de protrombina y TTPA alargados, y fibrinógeno de 90 miligramos por decilitro. **¿Cuál es la mejor indicación transfusional?**

A Crioprecipitado
B Glóbulos rojos
C Plaquetas
D Sangre fresca
E Plasma fresco congelado

Respuesta E. Tiempos de coagulación alargados con fibrinógeno bajo, en el contexto de una hemorragia postparto: es una coagulación intravascular diseminada, la T de trombina. El plasma fresco congelado repone los factores de coagulación consumidos.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 48 años en UCI por shock séptico urinario por E. coli BLEE. Al segundo día presenta sangrado continuo por sitios de punción, equimosis espontáneas y hematuria. Plaquetas 28.000/µL (previas 180.000), TP 26 s (INR 2,4), TTPK 68 s, fibrinógeno 70 mg/dL, dímero D > 20.000 ng/mL, esquistocitos 2%. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar heparina no fraccionada en infusión continua
B Plasmaféresis urgente
C Mantener antibióticos y soporte, más crioprecipitado, plasma fresco congelado y plaquetas
D Vitamina K 10 mg EV como única medida
E Suspender hemocomponentes y controlar el perfil en 24 horas

Respuesta C. CID manifiesta por sepsis (score ISTH 8: plaquetas 2 + dímero D 3 + TP 2 + fibrinógeno 1) con sangrado activo. Se trata la causa y se da soporte dirigido: crioprecipitado por fibrinógeno < 100, plasma por TP y TTPK prolongados, y plaquetas con meta > 50.000. La heparina está contraindicada si predomina el sangrado; la plasmaféresis es del PTT.

▶ VER CLASE 1.08.2.002 **Coagulopatía adquirida** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.14 · Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes

QUÉ HAY QUE SABER

- Paciente que sangra con TP prolongado: pensar en anticoagulante oral, déficit de vitamina K (colestasis, antibióticos, malabsorción, desnutrición) o daño hepático (factor V bajo, no corrige con vitamina K).
- Cumarínico con sangrado grave (cualquier INR): suspender y revertir con complejo protrombínico 25–50 UI/kg + vitamina K 10 mg EV lenta; sin CCP, plasma fresco 15 mL/kg.
- Sin sangrado: INR 4,5–10 suspender 1–2 dosis; INR >10 vitamina K oral 2,5–5 mg; sangrado leve igual que INR >10.
- Déficit de vitamina K: vitamina K parenteral, normaliza el TP en 12–24 h. Dabigatrán: idarucizumab 5 g EV; anti-Xa: andexanet o CCP 50 UI/kg; heparina: protamina.
- Seguimiento completo: reajustar anticoagulación con control de INR y revisar interacciones (amiodarona, metronidazol, ciprofloxacino, cotrimoxazol potencian el cumarínico).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 96

Un paciente de 55 años con antecedentes de hipertensión arterial y una válvula cardíaca aórtica mecánica, anticoagulado con antagonistas de la vitamina K, ingresa al servicio de urgencias por un episodio de hemorragia digestiva alta, con signos de inestabilidad hemodinámica. Además de la administración de fluidos y la solicitud de una endoscopía digestiva alta con urgencia, **¿cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?**

A Administrar vitamina K por vía endovenosa

B Transfundir sangre completa

C Administrar ácido tranexámico endovenoso

D Administrar plasma fresco congelado endovenoso

E Administrar factor VII recombinante endovenoso

Respuesta D. Sangrado grave con inestabilidad en un paciente con antagonista de la vitamina K: se necesita reposición inmediata de factores. La primera elección es el CCP, que no aparece entre las alternativas; su alternativa es el plasma fresco congelado, junto con vitamina K EV. La vitamina K sola demora horas en actuar.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 71 años con fibrilación auricular en tratamiento con acenocumarol consulta por hematemesis y melena de 6 horas, con mareo ortostático. PA 90/55 mmHg, FC 112 lpm, palidez y sudoración fría. Hb 7,8 g/dL, plaquetas 210.000/µL, INR 8,5. **Además de la reanimación y la endoscopía, ¿cuál es la conducta más adecuada respecto de la anticoagulación?**

A Suspender 1 a 2 dosis de acenocumarol y controlar INR en 24 horas

B Suspender acenocumarol y dar vitamina K1 oral 2,5 a 5 mg

C Concentrado de complejo protrombínico 25–50 UI/kg EV más vitamina K 10 mg EV lenta

D Sulfato de protamina EV

E Idarucizumab 5 g EV

Respuesta C. Hemorragia digestiva alta con inestabilidad hemodinámica: sangrado grave con riesgo vital. Con cualquier INR, se suspende el cumarínico y se revierte de inmediato con CCP de 4 factores más vitamina K 10 mg EV en infusión lenta. La vitamina K oral es para el INR sobre 10 sin sangrado o el sangrado leve; protamina e idarucizumab son antídotos de heparina y dabigatrán.

▶ VER CLASE 1.08.2.003 Coagulopatía congénita sangrante

DX SOSPECHA · TX INICIAL · SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Hematología 8.13 · Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

QUÉ HAY QUE SABER

- Paciente con hemofilia o von Willebrand que sangra: hemartrosis, hematoma muscular (psoas: dolor inguinal, cadera en flexión, compromiso femoral), síndrome compartimental, sangrado del SNC o posquirúrgico.
- Regla: infundir el concentrado de factor de inmediato, antes de radiografía o TAC.
- Hemofilia A: 1 UI/kg de VIII sube 2 %; hemartrosis 25–30 UI/kg (meta 40–50 %); SNC o politrauma 50 UI/kg (meta 100 %). Hemofilia B: 1 UI/kg de IX sube 1 %; hemartrosis 40–50 UI/kg, riesgo vital 100 UI/kg.
- Von Willebrand tipo 1: desmopresina (vigilar hiponatremia); tipos 2–3 o sangrado grave: concentrado de VIII con factor von Willebrand. Ácido tranexámico en sangrado oral, no en hematuria.
- Nunca AINE ni aspirina (analgesia con paracetamol u opioides), inyecciones IM ni punción de la hemartrosis. Inmovilizar y frío local.
- Seguimiento: derivar a centro de hemofilia (cobertura GES).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 5 años con dolor intenso y aumento de volumen de la rodilla derecha de 6 horas, tras una caída menor. Rodilla caliente, a tensión, en flexión fija. Un tío materno murió joven por una "enfermedad de la sangre". Hb 12 g/dL, plaquetas 280.000/µL, TP 12,1 s, TTPK 62 s (control 29 s). El médico de turno pide aguja y jeringa para puncionar la rodilla. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Artrocentesis diagnóstica y evacuadora

B Ibuprofeno oral e inmovilización

C Infundir concentrado de factor VIII de inmediato

D Radiografía de rodilla antes de decidir

E Desmopresina endovenosa

Respuesta C. Hemartrosis en un niño con TTPK prolongado aislado y tío materno fallecido por hemorragia: hemofilia. Se infunde factor VIII de inmediato (≈30 UI/kg, meta 50 %), se inmoviliza y se aplica frío. La artrocentesis está contraindicada, los AINE están prohibidos, no se espera la radiografía y la desmopresina es para el von Willebrand tipo 1.

▶ VER CLASE 1.08.2.004 Hipercalcemia

DX SOSPECHA · TX INICIAL · SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 7.16 · Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico
Hematología 8.22 · Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

QUÉ HAY QUE SABER

- Clínica: poliuria y polidipsia, deshidratación, constipación, náuseas, confusión hasta coma, QT corto. Corregir por albúmina: Ca + 0,8 × (4 – albúmina).

- Severidad: leve <12 mg/dL; moderada 12–13,9 (hospitalizar); crisis ≥14 mg/dL con compromiso de conciencia, arritmias o falla renal.
- Primer examen etiológico: PTH intacta. Alta o inapropiadamente normal: hiperparatiroidismo primario; suprimida: neoplasia (PTHrP en epidermoide, metástasis osteolíticas de mama, mieloma) o exceso de vitamina D (linfoma, granulomas).
- Manejo inicial: suero fisiológico 0,9 % 200–300 mL/h (3–4 L en 24 h) primero; luego ácido zoledrónico 4 mg EV (efecto 48–72 h); calcitonina como puente; furosemida solo si hay sobrecarga.
- Corticoides si linfoma, mieloma o sarcoidosis; hemodiálisis si falla renal refractaria. Suspender tiazidas, litio y calcio.
- Seguimiento: derivar a oncología o endocrinología según la causa.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 156

Un paciente de 64 años, con antecedente de haber sido tratado por un mieloma, con buena respuesta, consulta ahora por cuadro de astenia, con constipación y aumento del volumen urinario, a lo que luego se le agrega desorientación. Al examen físico se aprecia soporoso, pálido. En sus exámenes presenta hematocrito 27%, con Hb: 9 g/dl, VHS: 93 mm/h, proteínas plasmáticas: 7,8 g/dl, albúmina: 3,7 g/dl, sodio: 140 mEq/L, potasio: 4,8 mEq/L, calcio: 14,3 mg/dl. **En este momento debe recibir:**

A Calcitonina
B Solución salina al 0,9%
C Vitamina D
D Bifosfonatos
E Corticoides

Respuesta B. Hipercalcemia grave (14,3 mg/dL) sintomática en un paciente con mieloma: constipación, poliuria y compromiso de conciencia. Lo primero es hidratar en forma vigorosa con solución salina al 0,9% endovenosa; los bifosfonatos son parte del manejo óseo, pero no son el primer paso.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 105

Paciente con cáncer de próstata y calcemia de 14 mg/dL. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Bifosfonatos endovenosos (ácido zoledrónico)
B Suero fisiológico endovenoso (hidratación agresiva)
C Calcitonina intranasal
D Prednisona oral 40 mg/día
E Diálisis de urgencia

Respuesta B. Hipercalcemia maligna severa: lo primero es corregir la deshidratación por diuresis osmótica con suero fisiológico EV abundante. Luego se agrega ácido zoledrónico, que tarda 2 a 4 días en actuar. La calcitonina es un puente rápido y breve; los corticoides sirven en linfomas y mieloma; la diálisis queda para falla renal o cardíaca que impida hidratar.

▶ VER CLASE 1.08.2.005 Lisis tumoral aguda

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.22 · Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar a las 12–72 h de iniciar quimioterapia (o espontáneo) en tumores de recambio rápido: linfoma de Burkitt, LLA, leucocitos >100.000.
- Cairo-Bishop (≥2): ácido úrico ≥8 mg/dL, potasio ≥6 mEq/L, fósforo ≥4,5 mg/dL, calcio corregido ≤7 mg/dL. Clínico si se suma falla renal (creatinina 1,5 veces), arritmias o convulsiones.
- Prevención: hiperhidratación con suero fisiológico 2,5–3 L/m²/día desde 24–48 h antes; alopurinol 300 mg/día en riesgo bajo-intermedio, rasburicasa 0,2 mg/kg EV en alto riesgo (contraindicada en déficit de G6PD). No alcalinizar la orina.
- Hiperkalemia con cambios en ECG: primero gluconato de calcio 10 % EV lento; luego insulina + glucosa y salbutamol.
- Hemodiálisis de urgencia si anuria o hiperkalemia refractaria.
- Seguimiento: no requiere seguimiento específico una vez resuelto.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 20

Un paciente de 55 años, diagnosticado con un linfoma no Hodgkin con múltiples masas mediastínicas y abdominales de gran tamaño, de hasta 25 cm, inicia quimioterapia endovenosa. Al tercer día evoluciona con malestar general marcado, obnubilación y disnea. Al examen físico, se aprecia desorientado en el tiempo y el espacio, en malas condiciones generales y se solicitan exámenes de laboratorio, entre los que destacan ácido úrico: 13 mg/dL, sodio: 140 mEq/L, potasio: 5,9 mEq/L, fósforo: 6,5 mg/dl, creatinina plasmática: 2,1 mg/dl y hematocrito 22%. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hipercalcemia maligna
B Metástasis cerebrales
C Síndrome de vena cava superior
D Síndrome de compresión medular
E Síndrome de lisis tumoral

Respuesta E. Linfoma de gran masa, al tercer día de la quimioterapia, con hiperuricemia (13), hiperfosfemia (6,5), potasio en el límite y falla renal: síndrome de lisis tumoral clásico. Se trata con hidratación, hipouricemiante y manejo de los electrolitos.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 21 años con linfoma de Burkitt abdominal (masa retroperitoneal de 12 cm) inicia su primer ciclo de quimioterapia intensiva. A las 24 horas presenta oliguria, náuseas y parestesias peribucales. ECG: ondas T picudas y QRS ancho. Creatinina 3,1 mg/dL (basal 0,9), K 6,8 mEq/L, ácido úrico 14,5 mg/dL, fósforo 7,8 mg/dL, calcio 6,2 mg/dL. **¿Cuál es la primera medida?**

A Bicarbonato de sodio EV para alcalinizar la orina

B Alopurinol 300 mg VO

C Gluconato de calcio al 10% EV lento

D Suspender la hidratación por la oliguria

E Ácido zoledrónico 4 mg EV

Respuesta C. Lisis tumoral clínica (4 criterios de Cairo-Bishop más falla renal) con hiperkalemia y cambios en el ECG. Lo primero es estabilizar la membrana cardíaca con gluconato de calcio al 10% EV; luego insulina con glucosa y salbutamol, rasburicasa 0,2 mg/kg EV, hiperhidratación y hemodiálisis si hay anuria o hiperkalemia refractaria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 63

Paciente con linfoma en quimioterapia. Post primer ciclo presenta hiperuricemia, hiperkalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Creatinina en ascenso. ¿Cuál es el diagnóstico?

A Síndrome de lisis tumoral

B Insuficiencia renal aguda prerenal

C Nefrotoxicidad por cisplatino

D Síndrome hemolítico urémico

E Hiperparatiroidismo secundario

Respuesta A. Post quimioterapia: hiperuricemia + hiperkalemia + hiperfosfatemia + hipocalcemia + IRA = síndrome de lisis tumoral. Ocurre por destrucción masiva de células tumorales que liberan su contenido.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 106

Paciente con leucocitosis, 80% blastos linfoides, hiperuricemia, hipocalcemia y fósforo límite alto. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Quimioterapia de inducción inmediata

B Rasburicasa e iniciar quimioterapia

C Transfusión de glóbulos rojos y plaquetas

D Hemodiálisis urgente

E Suero fisiológico endovenoso y alopurinol (prevención de síndrome de lisis tumoral)

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Suero fisiológico endovenoso y alopurinol (prevención de síndrome de lisis tumoral) (opción E). Suero fisiológico endovenoso y alopurinol (prevención de síndrome de lisis tumoral).

▶ VER CLASE 1.08.2.006 Neutropenia febril

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.21 · Neutropenia Febril en Oncología: Estratificación MASCC, Monoterapia Antipseudomónica y Urgencia Médica

QUÉ HAY QUE SABER

- Definición: RAN <500/µL (o <1.000 con caída prevista) + fiebre ≥38,3 °C única o ≥38 °C por 1 hora; típicamente en el nadir (día 7–14 post quimioterapia).
- RAN = leucocitos × (% segmentados + % baciliformes)/100; RAN <100 es neutropenia profunda. Sin neutrófilos no hay pus: la fiebre puede ser el único signo.
- Hora de oro: 2 sets de hemocultivos (periféricos y por cada lumen del catéter) y antibiótico EV en <60 minutos; examinar boca, catéter y zona perianal. Nunca tacto ni termómetro rectal.
- Alto riesgo (MASCC <21): hospitalizar y monoterapia antipseudomónica con cefepime 2 g c/8 h o piperacilina/tazobactam 4,5 g c/6 h; meropenem si shock o sospecha de BLEE. Vancomicina solo con indicación (shock, catéter, SAMR).
- Bajo riesgo (MASCC ≥21), estable y con acceso: ciprofloxacino + amoxicilina/clavulánico oral ambulatorio con recontrol en 24 h.
- Fiebre persistente día 4–7 con cultivos negativos: TC de tórax, galactomanano y antifúngico. Seguimiento: derivar a oncología/hematología.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 61

Paciente con leucemia en quimioterapia. Recuento absoluto de neutrófilos: 400/mm³. Inicia fiebre 38.5°C. Inicia ATB de amplio espectro. A las 72 horas persiste febril sin foco identificado. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Agregar antifúngico empírico (anfotericina B liposomal o voriconazol)

B Cambiar antibiótico a vancomicina

C Realizar PET-CT para buscar foco

D Suspender ATB y observar

E Agregar metronidazol

Respuesta A. Neutropenia febril que no responde a antibióticos de amplio espectro y sin foco: se sospecha infección fúngica invasiva (aspergilosis o candidiasis) y se agrega antifúngico empírico (anfotericina B liposomal, voriconazol o equinocandinas). El libro sitúa este paso entre el 4.º y el 7.º día de fiebre persistente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 109

Una paciente de 55 años, en quimioterapia por leucemia mieloide aguda, inicia desde hace algunas horas fiebre alta, cefalea y dolor al movimiento ocular, refiere haber estado en contacto con su hijo que cursaba con cuadro respiratorio alto. Se realiza exámenes donde destaca hemoglobina 8.5 mg/dL, leucocitos 1.000/mm3 (10% neutrófilos 90% linfocitos) y plaquetas 80.000/mm3. **La conducta más adecuada frente a esta paciente es:**

A Indicar manejo sintomático

B Indicar Ceftazidima con amikacina endovenosas

C Indicar anfotericina B endovenoso

D Indicar oseltamivir endovenoso

E Indicar aislamiento e iniciar ceftriaxona endovenosa

Respuesta B. RAN = 1.000 × 10 % = 100/mm³ con fiebre: neutropenia febril. Lo que define la respuesta es la cobertura antipseudomónica EV inmediata; ceftazidima con amikacina es la única alternativa que la ofrece. Hoy el esquema de elección del libro es la monoterapia con cefepime. La ceftriaxona no cubre Pseudomonas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 7

Una paciente de 56 años tiene antecedentes de cáncer de mama, en tratamiento con quimioterapia cuyo último ciclo fue hace 9 días. Consulta porque ha presentado malestar general y fiebre hasta 38,5°C. Al examen físico, se confirma febril, con frecuencia cardíaca 95x', PA: 120/80, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A Hemograma

B Radiografía de tórax

C Urocultivo

D Ecografía abdominal

E Mielograma

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Urocultivo (opción C).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 164

Una niña de 7 años con antecedente de leucemia aguda en tratamiento con quimioterapia presenta fiebre de 24 horas de evolución hasta 38,7°C. Su última quimioterapia se realizó hace 10 días. Al examen físico está en buenas condiciones generales, sin alteraciones que identifiquen un foco infeccioso. Tiene una temperatura de 38,5°C y se solicita un hemograma que muestra 800 leucocitos por mm?, con un recuento absoluto de neutrófilos de 450 por mm?, 95.000 plaquetas por mm? y un hematocrito del 35%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Indicar paracetamol por vía oral más reposo relativo y observación

B Administrar ceftriaxona endovenosa durante la primera hora de atención

C Realizar TAC de tórax y abdomen

D Esperar el resultado del estudio etiológico antes de iniciar antibióticos

E Administrar esquema de cefotaxima y anfotericina B por vía endovenosa

Respuesta B. Manejo de la Neutropenia Febril: La neutropenia febril es una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato con antibióticos, idealmente dentro de los primeros 30 a 60 minutos del ingreso. El régimen de antibióticos debe cubrir Gram negativos y las guías internacionales recomiendan que se cubra también Pseudomonas aeruginosa, siendo cefepime o un carbapenémico las opciones preferidas. En Chile, si se trata de una neutropenia de bajo riesgo (clásico ejemplo los pacientes en quimioterapia...

▶ VER CLASE **1.08.2.007** **Síndrome de compresión medular** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.22 · Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en paciente oncológico (próstata, mama, pulmón, mieloma) con dolor raquídeo progresivo y nocturno, que empeora en decúbito.
- Signos de compromiso medular: paraparesia, nivel sensitivo en el tronco, hiperreflexia; la retención urinaria es tardía. El pronóstico depende de la función motora al inicio.
- Manejo inicial: dexametasona 16–24 mg EV ante la sola sospecha, sin esperar la imagen.
- Solicitar en paralelo RM de columna completa urgente (puede haber varios niveles).
- Seguimiento: derivar de urgencia a radioterapia descompresiva o neurocirugía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 71 años con cáncer de próstata con metástasis óseas conocidas. Hace 3 semanas presenta dorsalgia progresiva que empeora al acostarse y lo despierta de noche. Desde hace 24 horas tiene debilidad de ambas piernas y dificultad para orinar. Examen: paraparesia 4/5, hipoestesia con nivel sensitivo en T10, reflejos aumentados en extremidades inferiores y globo vesical. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Radiografía de columna dorsal y analgesia con opioides en domicilio

B Cintigrafía ósea ambulatoria

C Punción lumbar para citología

D Dexametasona EV, resonancia magnética de toda la columna urgente y evaluación por radioterapia y neurocirugía

E Iniciar bloqueo androgénico y control en 1 semana

Respuesta D. Dolor dorsal en un paciente oncológico con déficit motor, nivel sensitivo y retención urinaria: compresión medular metastásica, una emergencia. Se inicia dexametasona EV de inmediato, se solicita RM de toda la columna (puede haber varios niveles) y se decide radioterapia o descompresión quirúrgica en horas. El pronóstico depende de la función motora al inicio.

▶ VER CLASE 1.08.2.008

Síndrome vena cava superior

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.2 · Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome de vena cava superior: compresión mediastínica por tumor central (cáncer pulmonar, sobre todo microcítico) o adenopatías (linfoma).
- Clínica: edema en esclavina de cara, cuello y brazos, cianosis facial, ingurgitación yugular y circulación colateral torácica, disnea que empeora al acostarse.
- Confirmación: TAC de tórax con contraste y obtener diagnóstico histológico (biopsia) antes de tratar.
- Error frecuente: radioterapia empírica o corticoides antes de tener histología, salvo compromiso de vía aérea o edema cerebral.
- Manejo inicial: cabecera elevada, oxígeno; luego tratamiento según histología (quimioterapia en microcítico y linfoma, radioterapia, stent endovascular). Seguimiento: derivar a oncología.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años, fumador, consulta por edema de cara y cuello, plétora facial y disnea leve de 2 semanas, que empeora al agacharse. Se observa circulación colateral en la pared torácica anterior. Está vigil, sin estridor. La radiografía muestra ensanchamiento mediastínico superior derecho. No tiene diagnóstico oncológico previo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Radioterapia de urgencia antes de cualquier estudio

B TAC de tórax con contraste y obtención de diagnóstico histológico antes de tratar

C Corticoides empíricos en dosis altas y alta

D Diuréticos endovenosos como tratamiento definitivo

E Trombolisis sistémica

Respuesta B. Un síndrome de vena cava superior sin compromiso de vía aérea ni edema cerebral permite estudiar: se realiza TAC de tórax con contraste y biopsia, porque el tratamiento depende de la histología (quimioterapia en células pequeñas o linfoma). La radioterapia o los corticoides empíricos pueden impedir el diagnóstico. Si hay estridor o confusión, se instala un stent endovascular.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 66

Un paciente de 75 años, con diagnóstico de cáncer de células pequeñas, presenta un cuadro de 2 días de aumento de volumen de la cara, asociado a confusión mental y tos. Al examen físico está desorientado, tiene eritema y cianosis de la cara y se observa dilatación de las venas del cuello. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Solicitar resonancia magnética nuclear de tórax

B Administrar diuréticos por vía endovenosa

C Realizar quimioterapia de urgencia

D Realizar radioterapia de urgencia

E Realizar broncoscopía de urgencia

Respuesta D. Síndrome de vena cava superior: Caracterizado por obstrucción del flujo a través de la VCS con edema facial, distensión yugular, tos y disnea. En cáncer de células pequeñas, el tratamiento clásico es la radioterapia urgente (aunque actualmente se prefiere quimioterapia + stent).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 92

Un paciente de 35 años, consulta por un cuadro de 1 semana de malestar general, sensación de edema de la cara en la mañana y tos que ha ido aumentando. Al examen físico se constata una adenopatía cervical, yugulares ingurgitadas y edema facial y de las manos. Además tiene signos de derrame pleural bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Tuberculosis
B Hipotiroidismo
C Taponamiento cardíaco
D Mononucleosis infecciosa
E Síndrome de vena cava superior

Respuesta E. Es un síndrome de VCI clásico, probablemente secundario a un linfoma, dada la edad y las adenopatías.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 13

Un joven de 17 años presenta un cuadro de fiebre y baja de peso, con malestar general, de algunas semanas de evolución. Consulta ahora por un cuadro de rápida instalación de cefalea, tos, edema de extremidades superiores y de la cara, seguido de desorientación y sopor. ¿Qué examen es más adecuado para confirmar el diagnóstico en este paciente?

A Radiografía de tórax
B Ecocardiograma
C TAC de tórax con contraste
D Endoscopía digestiva alta
E Resonancia magnética nuclear

Respuesta C. Es un síndrome de vena cava superior, probablemente secundaria a un linfoma. El diagnóstico es clínico (no aparece en las opciones). El TAC es la mejor imagen para ver las adenopatías mediastínicas que producen el cuadro.

▶ VER CLASE **1.08.2.009** **Trombopenia severa** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.12 · Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Trombocitopenia severa con sangrado mucoso activo (epistaxis, gingivorragia, hematuria) o plaquetas <10.000–20.000/µL; confirmar en frotis (descartar pseudotrombocitopenia).
- Evaluar si es aislada (PTI), con esquistocitos (PTT/SHU), con coagulación alterada (CID) o con pancitopenia o blastos (aplasia, leucemia).
- PTI con sangrado relevante: hospitalizar, metilprednisolona EV en dosis altas + IgEV 1 g/kg/día; transfundir plaquetas solo con riesgo vital (hemorragia intracraneana).
- Microangiopatía trombótica: no transfundir plaquetas; plasmaféresis urgente en PTT.
- Umbrales de transfusión de plaquetas: <10.000 falla medular estable; <20.000 con fiebre; <50.000 para procedimientos o sangrado; <100.000 en SNC u ojo. Evitar AINE e IM.
- Seguimiento: derivar a hematología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 40 años, previamente sano, consulta en urgencia por epistaxis profusa que no cede con taponamiento anterior, gingivorragia y hematuria macroscópica de 12 horas. PA 118/72 mmHg, FC 98 lpm, lúcido, sin focalidad neurológica. Petequias y equimosis diseminadas, sin adenopatías ni esplenomegalia. Hb 11,8 g/dL, leucocitos 7.200/µL, plaquetas 4.000/µL (confirmadas en frotis, sin esquistocitos). TP y TTPK normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Prednisona 1 mg/kg/día oral y control ambulatorio en una semana
B Hospitalizar, metilprednisolona EV en dosis altas, inmunoglobulina EV y transfusión de plaquetas
C Esplenectomía de urgencia
D Plasmaféresis urgente
E Transfundir plasma fresco congelado

Respuesta B. Trombocitopenia aislada severa con frotis sin esquistocitos y coagulación normal: PTI con sangrado mucoso activo de riesgo. Es una urgencia: se hospitaliza, se dan corticoides EV en dosis altas más inmunoglobulina EV y, por el sangrado activo, plaquetas. El manejo ambulatorio solo corresponde sin sangrado relevante; la plasmaféresis es para PTT.

Conocimientos generales

12 códigos

▶ VER CLASE **1.08.3.001** **Alcoholismo y asociación con carencias nutricionales**

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.6 · Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

QUÉ HAY QUE SABER

- El alcoholismo crónico produce anemia macrocítica: por toxicidad directa (macrocitosis sin megaloblastos, VCM habitualmente <110) y por déficit de folato.
- El folato es la carencia que más frecuentemente da anemia megaloblástica en el bebedor: dieta pobre, malabsorción y efecto tóxico; sus reservas duran solo 3–4 meses (neutrófilos hipersegmentados).
- La B12 tiene reservas para 3–5 años; si hay neurología o macrocitosis marcada, medir B12 antes de dar folato (nunca ácido fólico solo).
- Déficit de tiamina (B1): suplementar siempre antes de administrar glucosa para prevenir encefalopatía de Wernicke.
- Otros: hepatopatía (macrocitosis por membrana, déficit de vitamina K con TP prolongado), hiperesplenismo con trombocitopenia, sangrado digestivo con ferropenia.
- Tratamiento: ácido fólico 1–5 mg/día por 3–4 meses, tiamina, abstinencia y apoyo nutricional.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 52 años con consumo diario de 1 litro de vino desde hace años y dieta muy pobre consulta por fatiga. Hemoglobina 10,2 g/dL, VCM 112 fL, neutrófilos hipersegmentados. Sin síntomas neurológicos. Transaminasas levemente elevadas. **¿Cuál es la carencia nutricional más probablemente responsable de su anemia?**

A Ácido fólico
B Hierro
C Vitamina B12 por anemia perniciosa
D Vitamina C
E Zinc

Respuesta A. En el alcoholismo crónico, la carencia que más frecuentemente produce anemia megaloblástica es el déficit de ácido fólico, por dieta pobre, malabsorción y efecto tóxico del alcohol; los neutrófilos hipersegmentados confirman la megaloblastosis. El alcoholismo también causa déficit de tiamina, que debe suplementarse. La B12 tiene reservas para años y su déficit suele dar síntomas neurológicos.

▶ VER CLASE 1.08.3.002 Conceptos generales de etapificación, radioterapia y quimioterapia

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.15 · Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

QUÉ HAY QUE SABER

- Etapificación: define la extensión del cáncer, el pronóstico y el tratamiento; sistema TNM (tumor, ganglios, metástasis) en tumores sólidos, Ann Arbor en linfomas (I a IV, sufijos A/B según síntomas B).
- Siempre confirmar con histología (biopsia) antes de etapificar o tratar; la etapificación usa imágenes (TAC de tórax, abdomen y pelvis, PET-CT, RM según tumor) y a veces cirugía (p. ej., cáncer de endometrio u ovario).
- Cirugía: tratamiento curativo de tumores sólidos localizados (p. ej., cáncer pulmonar no microcítico etapa I–II; citorreducción máxima en ovario).
- Quimioterapia: sistémica, curativa en tumores quimiosensibles (linfomas, leucemias, germinales, microcítico), adyuvante tras cirugía o paliativa; toxicidad: mielosupresión (nadir día 7–14, neutropenia febril), mucositis, náuseas, alopecia.
- Radioterapia: control local curativo, adyuvante o paliativo (dolor óseo, compresión medular); toxicidad local según el campo irradiado.
- Intención curativa vs paliativa se decide según estadio y estado funcional; el médico general pesquisa, deriva y maneja complicaciones (neutropenia febril, lisis tumoral, náuseas, dolor).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 4

Una paciente de 60 años es diagnosticada de cistoadenocarcinoma seroso de ovario con diseminación difusa en el peritoneo, por lo cual no es operable. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este caso?**

A Cuidados paliativos
B Radioterapia
C Hormonoterapia
D Quimioterapia
E Inmunoterapia

Respuesta D. El cáncer epitelial de ovario avanzado es muy quimiosensible: cuando la carga tumoral impide una citorreducción óptima, se indica quimioterapia sistémica con carboplatino y paclitaxel (neoadyuvante, evaluando cirugía de intervalo). La radioterapia no se usa en enfermedad peritoneal difusa, y derivar solo a cuidados paliativos negaría un tratamiento eficaz.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 117

Un paciente de 50 años, con antecedente de infección de VIH de varios años, consulta por una lesión perianal, de larga data, sin tendencia a la cicatrización, que en ocasiones se ulcera y sangra. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, de consistencia aumentada, de 3 cm de diámetro, bordes cartográficos y que se introduce por el orificio anal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Sífilis
B Enfermedad de Cröhn
C Carcinoma epidermoide
D Melanoma
E Linfogranuloma venéreo

Respuesta C. Una lesión ulcerada, indurada y de larga data en el canal anal de un paciente con VIH corresponde a un carcinoma epidermoide del ano, cuyo riesgo aumenta con la inmunosupresión y la infección por virus papiloma humano. Debe biopsiarse. La sífilis y el linfogranuloma venéreo dan úlceras o adenopatías de curso más agudo, la enfermedad de Crohn rara vez se presenta como una lesión indurada única y el melanoma anal es mucho menos frecuente.

▶ VER CLASE 1.08.3.003 Efectos mielotóxicos de drogas y medicamentos

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.5 · Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Fármacos mielotóxicos clásicos: cloranfenicol, antitiroideos (tiamazol, propiltiouracilo), carbamazepina, fenitoína, sulfas, sales de oro, citostáticos; también clozapina (agranulocitosis ~0,8 %).
- Tóxicos: benceno, organofosforados y radiación; pueden causar aplasia medular (pancitopenia sin esplenomegalia).
- Fármacos que alteran el folato y dan macrocitosis: metotrexato, trimetoprima, pirimetamina, fenitoína; metformina e IBP crónicos bajan la B12.
- Ante fiebre u odinofagia en usuario de antitiroideos o clozapina: hemograma urgente; si hay neutropenia grave, suspender el fármaco de inmediato y tratar como neutropenia febril.
- Clozapina: hemograma basal (leucocitos ≥3.500, RAN ≥2.000), semanal las primeras 26 semanas, quincenal hasta el año y luego mensual; RAN <1.000 suspender para siempre.
- Quimioterapia: nadir del recuento a los 7–14 días; vigilar con hemograma antes de cada ciclo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 32 años con enfermedad de Graves en tratamiento con tiamazol 20 mg/día desde hace 5 semanas. Consulta en urgencias por fiebre de 38,8 °C, odinofagia con úlceras orales necróticas y petequias en extremidades inferiores. Sin esplenomegalia ni adenopatías. Hb 7,8 g/dL, leucocitos 900/µL, RAN 120/µL, plaquetas 14.000/µL, reticulocitos 0,2 %. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Reducir el tiamazol a 10 mg/día y controlar el hemograma en una semana
B Cambiar tiamazol por propiltiouracilo y dar antibiótico oral ambulatorio
C Suspender el tiamazol, hospitalizar en aislamiento, antibióticos EV de amplio espectro y derivar a hematología
D Indicar ácido fólico y hierro oral y controlar en un mes
E Iniciar prednisona 1 mg/kg por sospecha de PTI

Respuesta C. Pancitopenia grave (RAN < 200, plaquetas < 20.000, reticulocitos < 1 %) sin organomegalia en usuaria de tiamazol: aplasia medular medicamentosa con neutropenia febril de alto riesgo. Se suspende el tiamazol, se hospitaliza en aislamiento protector con antibiótico EV empírico (ceftazidima o piperacilina/tazobactam), se transfunden plaquetas si sangra y se deriva con urgencia a hematología para biopsia medular.

▶ VER CLASE 1.08.3.004 Actividad física en pacientes con riesgo de trombosis

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.4 · Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación

QUÉ HAY QUE SABER

- La estasis venosa (reposo >3 días, vuelos >6–8 h) es factor de riesgo de TEV junto a cirugía ortopédica mayor, fracturas, cáncer, trombofilias y estrógenos.
- En TVP o TEP con anticoagulación efectiva se indica deambulación precoz según tolerancia; el reposo absoluto en cama no previene embolia y aumenta el riesgo.
- Pacientes hospitalizados o postoperados: movilización precoz y tromboprofilaxis farmacológica (HBPM) o mecánica según riesgo.
- Viajes largos: caminar y mover las piernas periódicamente, hidratación, evitar ropa ajustada; medias de compresión en alto riesgo.
- La actividad física regular se recomienda en pacientes con antecedente de trombosis; evitar deportes de contacto con alto riesgo de trauma mientras estén anticoagulados.
- Evitar inmovilización prolongada sin profilaxis en paciente con cáncer, trombofilia o TEV previo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años con trombosis venosa profunda femoropoplítea izquierda, hemodinámicamente estable y sin signos de TEP, inicia anticoagulación ambulatoria con rivaroxabán. Pregunta si debe guardar reposo en cama. **¿Cuál es la recomendación más adecuada?**

A Reposo absoluto en cama por 2 semanas para evitar una embolia

B Reposo con la pierna en declive

C No caminar hasta que desaparezca el edema

D Deambulación precoz según tolerancia, con anticoagulación efectiva

E Ejercicio intenso de alto impacto desde el primer día

Respuesta D. Con anticoagulación efectiva, la deambulación precoz en la TVP es segura: no aumenta el riesgo de TEP y reduce dolor, edema y síndrome postrombótico. El reposo en cama favorece la estasis venosa. En personas con riesgo de trombosis, como en viajes largos o en el posoperatorio, se recomienda movilización, ejercicios de pantorrilla e hidratación.

▶ VER CLASE 1.08.3.005 Indicaciones de uso de componentes sanguíneos

DÓNDE SE ENSEÑA

Hematología 8.15 · Coagulación Intravascular Diseminada (CID): Criterios ISTH, Sepsis/Obstetricia y Manejo
Hematología 8.24 · Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas

QUÉ HAY QUE SABER

- Glóbulos rojos con estrategia restrictiva: transfundir con Hb <7 g/dL en estable (meta 7–8); <8–9 en síndrome coronario agudo; <8 en cirugía ortopédica/vascular. Cada unidad sube ~1 g/dL de Hb. Hemorragia masiva: protocolo 1:1:1.
- En anemias crónicas (ferropénica, megaloblástica) se transfunde por la clínica (inestabilidad, angina, disnea de reposo), no por la cifra.
- Plaquetas: <10.000 falla medular estable; <20.000 con fiebre o infección; <50.000 con sangrado o procedimiento (punción lumbar, biopsia hepática); <100.000 en SNC u ojo. Un pool o aféresis sube 30.000–50.000. Nunca en PTT ni SHU.
- Plasma fresco congelado 10–15 mL/kg: sangrado o procedimiento con TP o TTPK >1,5 veces, transfusión masiva, plasmaféresis en PTT. No como expansor ni para corregir INR sin sangrado.
- Crioprecipitado: reponer fibrinógeno <100–150 mg/dL con sangrado (CID, hemorragia masiva, desprendimiento de placenta).
- Productos desleucocitados e irradiados en aplasia y candidatos a trasplante; compatibilidad ABO: O donante de glóbulos rojos, AB receptor universal.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años con cirrosis hepática alcohólica Child B, hospitalizado por una hemorragia digestiva alta variceal. Mientras se prepara la endoscopía persiste con hematemesis. PA 96/60 mmHg tras cristaloides y glóbulos rojos. Hb 7,4 g/dL, plaquetas 82.000/µL, TP 38 % (INR 2,1), TTPK 52 s (control 30 s), fibrinógeno 160 mg/dL. **Respecto del plasma fresco congelado, ¿en cuál de las siguientes situaciones está mejor indicado?**

A Corregir un INR de 1,8 en un cirrótico estable sin sangrado ni procedimiento programado

B Tratar una hipoalbuminemia de 2,0 g/dL

C Expandir volumen en un shock hipovolémico sin coagulopatía

D Sangrado activo con déficit de múltiples factores (TP y TTPK prolongados sobre 1,5 veces el control), como en este paciente

E Revertir la anticoagulación por dabigatrán

Respuesta D. El plasma fresco congelado aporta todos los factores y se indica ante sangrado activo, o procedimiento invasivo, con déficit de múltiples factores (TP o TTPK sobre 1,5 veces). No se usa como expansor de volumen ni para tratar la albúmina, ni para corregir un INR sin sangrado. El dabigatrán se revierte con idarucizumab.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años, sin cardiopatía, hospitalizado en sala por una neumonía adquirida en la comunidad, en su tercer día de antibióticos y con buena evolución. Asintomático en reposo. PA 124/76 mmHg, FC 84 lpm, SatO2 96 % ambiental. Sin sangrado. Hb 7,6 g/dL (al ingreso 8,9 g/dL), VCM 86 fL, plaquetas 210.000/µL. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la transfusión?**

A Transfundir 2 unidades de glóbulos rojos para llevar la Hb sobre 10 g/dL

B Iniciar eritropoyetina subcutánea

C Transfundir 1 unidad de glóbulos rojos con furosemida

D Transfundir plasma fresco congelado

E No transfundir: controlar la Hb, estudiar la anemia y tratar su causa

Respuesta E. En pacientes hospitalizados estables y sin cardiopatía isquémica activa se usa una estrategia restrictiva: se transfunde con Hb menor de 7 g/dL (menor de 8 g/dL en cardiópatas o cirugía cardíaca y ortopédica) o ante síntomas. Con Hb 7,6 y asintomático no se transfunde; se estudia la anemia. Buscar Hb sobre 10 no mejora el pronóstico.

▶ VER CLASE 1.08.3.006 Interacción de drogas y anticoagulantes orales

DÓNDE SE ENSEÑA

Hematología 8.14 · Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes

QUÉ HAY QUE SABER

- Cumarínicos (acenocumarol, warfarina) inhiben la VKORC1; meta INR 2–3 (válvula mecánica mitral 2,5–3,5). Muchas interacciones por metabolismo hepático (CYP2C9).

- Potencian el efecto (sube INR, riesgo de sangrado): amiodarona, metronidazol, ciprofloxacino, cotrimoxazol, otros antibióticos (alteran flora productora de vitamina K).
- Disminuyen el efecto (baja INR): inductores enzimáticos como rifampicina, carbamazepina, fenobarbital; también dieta rica en vitamina K.
- AINE y antiagregantes aumentan el riesgo de sangrado sin cambiar el INR; preferir paracetamol para analgesia.
- Al iniciar o suspender un fármaco que interactúa, controlar INR en 3–5 días y ajustar dosis.
- Sobreanticoagulación: INR 4,5–10 sin sangrado suspender 1–2 dosis; INR >10 vitamina K oral 2,5–5 mg; sangrado grave complejo protrombínico + vitamina K EV.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 74 años con fibrilación auricular en tratamiento con acenocumarol, con INR estable entre 2 y 3 durante el último año y sin cambios en su dieta. Consulta por gingivorragia y equimosis en los brazos. INR 6,4. Hace 6 días se le inició un nuevo fármaco. **¿Cuál de los siguientes fármacos explica mejor este hallazgo?**

A Rifampicina

B Carbamazepina

C Cotrimoxazol

D Fenobarbital

E Espironolactona

Respuesta C. El cotrimoxazol inhibe el metabolismo hepático (CYP2C9) del cumarínico y además altera la flora productora de vitamina K, elevando bruscamente el INR. Rifampicina, carbamazepina y fenobarbital son inductores enzimáticos: aceleran el metabolismo y bajan el INR. Al iniciar un fármaco que interactúa, se debe controlar el INR en 3 a 5 días.

▶ VER CLASE 1.08.3.007 Manejo del dolor crónico y paliativo

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.26 · Cuidados Paliativos, Dolor Crónico y Final de Vida

QUÉ HAY QUE SABER

- Evaluar el dolor con escala numérica o visual análoga y clasificarlo (nociceptivo somático/visceral o neuropático); en Chile el alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos tiene garantía GES.
- Escalera analgésica OMS: dolor leve paracetamol o AINE; moderado opioide débil (tramadol, codeína) ± coadyuvante; severo opioide potente (morfina oral de elección), con dosis horaria y rescates.
- Morfina: iniciar 5–10 mg c/4 h vía oral en paciente sin opioide previo, titular según rescates; vía subcutánea si no puede tragar. Siempre asociar laxante y antiemético inicial.
- Efectos adversos de opioides: constipación (no desarrolla tolerancia), náuseas, sedación, mioclonías; depresión respiratoria rara si se titula. Antídoto: naloxona.
- Dolor neuropático: coadyuvantes como gabapentina, pregabalina, amitriptilina; dolor óseo metastásico: AINE, corticoides, radioterapia paliativa.
- Manejo integral con equipo de cuidados paliativos: considerar dimensión psicológica, social y espiritual (dolor total).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 70 años con cáncer de páncreas metastásico presenta dolor abdominal intenso (EVA 8/10) pese a paracetamol y tramadol en dosis máximas. Se decide iniciar morfina oral de liberación inmediata. **¿Qué indicación debe asociarse siempre al inicio de la morfina?**

A Naloxona profiláctica

B Antihistamínico para evitar la dependencia

C Benzodiacepina nocturna

D Suspender todos los coadyuvantes

E Laxante en forma regular

Respuesta E. La constipación es el efecto adverso más frecuente de los opioides y no genera tolerancia, por lo que debe indicarse un laxante regular desde el inicio, como lactulosa o polietilenglicol con un estimulante. Según la escalera analgésica de la OMS, ante dolor intenso se pasa a un opioide fuerte, manteniendo paracetamol y coadyuvantes. La naloxona solo se usa en sobredosis.

▶ VER CLASE 1.08.3.008 Manejo del paciente terminal oncológico

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.26 · Cuidados Paliativos, Dolor Crónico y Final de Vida

QUÉ HAY QUE SABER

- Paciente terminal oncológico: enfermedad avanzada, progresiva e incurable, sin respuesta a tratamiento específico y pronóstico de vida limitado; objetivo es el confort y la calidad de vida (GES cuidados paliativos por cáncer avanzado).
- Control de síntomas: dolor con escalera OMS y morfina; disnea con morfina en dosis bajas y oxígeno si hay hipoxemia; náuseas con metoclopramida o haloperidol; constipación con laxantes.
- Delirium terminal: buscar causas reversibles; haloperidol de elección. Estertores premortem: posición y anticolinérgicos (butilbromuro de hioscina).
- Vía subcutánea de elección cuando falla la vía oral; suspender fármacos e intervenciones fútiles (exámenes de rutina, hidratación agresiva).
- Comunicación honesta del pronóstico, respeto de la autonomía y voluntades anticipadas; adecuación del esfuerzo terapéutico y sedación paliativa para síntomas refractarios.

- Apoyo a la familia y cuidador, atención domiciliaria y acompañamiento en el duelo, con equipo multidisciplinario.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 81 años con cáncer pulmonar avanzado, en sus últimas horas de vida e inconsciente, presenta respiración ruidosa con estertores por secreciones en la vía aérea superior. La familia está angustiada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Aspiración traqueal profunda frecuente

B Furosemida endovenosa en dosis altas

C Butilbromuro de escopolamina subcutáneo, posición lateral y explicación a la familia

D Intubación orotraqueal

E Antibióticos de amplio espectro

Respuesta C. Los estertores premortem se deben a secreciones que el paciente ya no puede deglutir. Se manejan con posición lateral, reducción de la hidratación parenteral y antimuscarínicos como butilbromuro de escopolamina subcutáneo, explicando a la familia que no implican sufrimiento. La aspiración profunda es molesta y poco eficaz, y la intubación o los antibióticos no corresponden al final de vida.

▶ VER CLASE 1.08.3.009 Prevención de anemias por carencias nutricionales

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.4 · Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)

QUÉ HAY QUE SABER

- Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses; contraindicaciones: VIH, HTLV, TBC bacilífera activa no tratada, drogas, quimioterapia; galactosemia en el lactante.
- Hierro profiláctico: recién nacido de término 1 mg/kg/día desde los 4 meses hasta el año; prematuro o bajo peso 2–3 mg/kg/día desde los 2 meses.
- Vitamina D 400 UI/día desde el mes de vida hasta el año, para todos.
- Alimentación complementaria a los 6 meses (almuerzo) y a los 8–9 meses (cena) con carnes; no leche de vaca entera, miel, sal ni azúcar el primer año.
- Embarazo: ácido fólico periconcepcional (prevención de defectos del tubo neural) y suplemento de hierro; programas alimentarios chilenos (PNAC) en embarazadas y niños.
- Grupos de riesgo de B12: veganos estrictos, gastrectomizados o bypass (B12 profiláctica de por vida), usuarios crónicos de metformina o IBP.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 4 meses, nacido de término con peso adecuado, recibe lactancia materna exclusiva y crece normalmente. La madre consulta en el control de salud. **Según la norma MINSAL, ¿cuál es la indicación para prevenir la anemia ferropénica?**

A No requiere suplementación por recibir lactancia materna

B Hierro 6 mg/kg/día desde el nacimiento

C Suspender la lactancia e iniciar fórmula fortificada

D Hierro 1 mg/kg/día desde los 4 meses hasta el año

E Iniciar carne a los 2 meses de vida

Respuesta D. Las reservas de hierro del lactante de término se agotan hacia los 4 a 6 meses y la leche materna aporta poco hierro. La norma indica hierro 1 mg/kg/día desde los 4 hasta los 12 meses en lactancia materna exclusiva (en prematuros, 2 mg/kg/día desde los 2 meses), junto con alimentación complementaria rica en hierro desde los 6 meses.

▶ VER CLASE 1.08.3.010 Prevención de infecciones con énfasis en inmunosuprimidos

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.2 · Infecciones Oportunistas Mayores en VIH/SIDA

QUÉ HAY QUE SABER

- VIH según CD4: <200 Pneumocystis (cotrimoxazol forte 1 comp/día); <100 con IgG+ Toxoplasma (cotrimoxazol); <50 MAC (azitromicina 1.200 mg/semana); suspender con CD4 sobre umbral ≥3 meses con TARV.
- Tuberculosis latente: en VIH PPD ≥5 mm (inmunocompetente ≥10 mm) con TBC activa descartada → isoniazida + piridoxina.
- Inmunosupresión por fármacos (vasculitis, corticoides en dosis altas, rituximab o ciclofosfamida): profilaxis de Pneumocystis con cotrimoxazol.
- Neutropenia <500 o trasplante de médula: aislamiento protector, higiene de manos; evitar inyecciones IM y tacto rectal.
- Esplenectomizados o asplenia funcional (drepanocitosis): vacunar contra neumococo, meningococo y Haemophilus al menos 2 semanas antes de la esplenectomía.
- Vacunas inactivadas en inmunosuprimidos (influenza anual, neumococo); evitar vacunas vivas atenuadas en inmunosupresión severa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 38 años con diagnóstico reciente de infección por VIH, asintomática, con CD4 de 140 células/mm3 e IgG para Toxoplasma positiva. Inicia terapia antirretroviral. **¿Cuál es la profilaxis más adecuada?**

A No requiere profilaxis hasta que el CD4 baje de 50
B Fluconazol diario
C Azitromicina semanal
D Aciclovir diario
E Cotrimoxazol diario

Respuesta E. Con CD4 bajo 200 se indica profilaxis primaria de Pneumocystis jirovecii con cotrimoxazol, que con CD4 bajo 100 y Toxoplasma IgG positivo también previene la toxoplasmosis cerebral. Se suspende cuando el CD4 se mantiene sobre 200 con TARV. Azitromicina para MAC ya no se indica si se inicia TARV, y fluconazol y aciclovir no son profilaxis primaria rutinaria.

▶ VER CLASE 1.08.3.011 Transfusión y sus complicaciones

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.24 · Medicina Transfusional y Manejo de Hemocomponentes: Glóbulos Rojos, Plaquetas, Plasma y Reacciones Adversas

QUÉ HAY QUE SABER

- Ante cualquier síntoma durante la transfusión: detener de inmediato, mantener vía con suero fisiológico y equipo nuevo, verificar identidad paciente-bolsa y notificar al banco de sangre (bolsa + muestras).
- Reacción hemolítica aguda (incompatibilidad ABO por error de identificación): en 10–15 min fiebre, calofríos, dolor lumbar, hipotensión, orina oscura, CID; soporte y diuresis forzada >100 mL/h.
- Reacción febril no hemolítica: la más frecuente (1–2 %), alza ≥1 °C sin hemólisis; paracetamol; se previene con productos desleucocitados.
- TRALI: disnea con hipotensión, yugulares normales, edema no cardiogénico en <6 h (anti-HLA del donante); soporte ventilatorio, sin diuréticos.
- TACO: disnea con hipertensión, ingurgitación yugular, BNP alto, en anciano o cardiópata con infusión rápida; furosemida 20–40 mg EV y sentar al paciente.
- Otras: alérgica/anafiláctica (antihistamínico o adrenalina), infecciosa (contaminación bacteriana) y sobrecarga de hierro en politransfundidos (quelantes).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 14

Una paciente de 68 años sufre un accidente de tránsito, resultando con fractura de pelvis inestable y hemorragia masiva, ingresando para su manejo en la unidad de paciente crítico. Al examen físico está taquicárdica e hipotensa, por lo que se solicitan pruebas de grupo y Rh, resultando su grupo sanguíneo O-Rh negativo. Sin embargo, en el hospital únicamente hay dos unidades de glóbulos rojos O-Rh negativo, aunque múltiples unidades O-Rh positivo. El hospital más cercano con unidades O-Rh negativo disponibles está a 4 horas de traslado. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Administrar cristaloides hasta conseguir más unidades O-Rh negativo
B Administrar las dos unidades O-Rh negativo y, en caso necesario, las O-Rh positivo
C Esperar a obtener más unidades O-Rh negativo, solicitándolas de inmediato a otro centro
D Administrar únicamente las dos unidades O-Rh negativo disponibles
E Trasladar de inmediato a otro hospital que tenga disponibles unidades O-Rh negativo

Respuesta B. En la hemorragia masiva la transfusión no espera. A diferencia del sistema ABO, en el sistema Rh se puede transfundir excepcionalmente sangre Rh positivo a un paciente Rh negativo cuando hay riesgo vital, porque el riesgo de hemólisis es menor que el de la anemia aguda severa.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 78 años con insuficiencia cardíaca con FE preservada e HTA, hospitalizada por anemia sintomática con Hb 6,4 g/dL. Durante la infusión rápida de la segunda unidad de glóbulos rojos presenta disnea súbita, FR 32, tos con expectoración rosada y cianosis. PA 185/100 mmHg (ingreso 130/80), FC 110, ingurgitación yugular hasta el ángulo mandibular y crépitos bilaterales hasta los ápices. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Disminuir la velocidad de infusión y completar la unidad
B Suspender la transfusión, sentarla, oxígeno y furosemida 40 mg EV
C Suspender la transfusión e iniciar ventilación protectora sin diuréticos
D Paracetamol y continuar la transfusión
E Hidratación salina masiva para diuresis forzada

Respuesta B. Anciana cardiópata con transfusión rápida que desarrolla edema pulmonar con hipertensión e ingurgitación yugular: TACO. Se suspende la transfusión, se sienta con las piernas declives, oxígeno a flujo alto y furosemida 40 mg EV en bolo. El soporte sin diuréticos corresponde al TRALI, que cursa con hipotensión.

▶ VER CLASE 1.08.3.012 Tratamiento anticoagulante

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.14 · Coagulopatías Adquiridas: Hepatopatía Crónica, Déficit de Vitamina K y Manejo de Anticoagulantes
Hematología 8.23 · Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: TVP/TEP, fibrilación auricular con riesgo embólico, válvulas mecánicas, SAF. TEP estable: ACOD de primera línea (rivaroxabán 15 mg c/12 h por 21 días y luego 20 mg/día, o apixabán 10 mg c/12 h por 7 días y luego 5 mg c/12 h).

- HBPM (enoxaparina 1 mg/kg c/12 h SC) de elección en cáncer activo y embarazo; cumarínicos con puente de heparina hasta INR 2–3 (válvula mecánica mitral 2,5–3,5).
- Heparina no fraccionada: monitorizar con TTPK 1,5–2,5 veces el control; vigilar plaquetas por trombocitopenia inducida por heparina.
- SAF: cumarínico de por vida, ACOD contraindicados (sobre todo triple positivo). Cumarínicos prohibidos en el embarazo (teratogénicos).
- Duración: TEV provocado 3–6 meses (mínimo 3); no provocado o recurrente, prolongada. Si no se puede anticoagular: filtro de vena cava inferior.
- Antídotos: cumarínico → vitamina K y complejo protrombínico; dabigatrán → idarucizumab; anti-Xa → andexanet o CCP; heparina → protamina.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 142

Paciente en tratamiento con acenocumarol por fibrilación auricular. INR actual 7,8 (meta 2–3). Sin sangrado activo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Suspender el acenocumarol y administrar vitamina K1 oral 2,5–5 mg

B Transfusión urgente de plasma fresco congelado

C Solo suspender el anticoagulante y observar

D Administrar protamina

E Continuar la misma dosis y controlar en 1 semana

Respuesta A. INR sobre 5 sin sangrado: se suspende el cumarínico y se da vitamina K1 oral en dosis baja para una reversión gradual, controlando el INR en 24 horas. El plasma o el complejo protrombínico se reservan para el sangrado grave; la protamina revierte la heparina, no los cumarínicos. No se busca revertir del todo, para no generar un estado protrombótico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 150

Paciente con ERC, con TVP poplítea, cual es la mejor terapia anticoagulante: a. Heparina no fraccionada

B Enoxaparina

C Dabigatran

D Rivaroxaban

E Acenocumarol 151. Mujer fumadora, hipertensa, con historia de ICC, pero que ahora estaba como desde hace unos 3 meses? Con disnea de esfuerzo, y al examen pulmonar estaba con sibilancias espiratorias,, y preguntaban por la causa del empeoramiento de los síntomas?

A TEP

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Enoxaparina).

Exámenes e imagenología

10 códigos

▶ VER CLASE 1.08.4.001 **Radiografía de tórax** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.18 · Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones en hémato-oncología: masa mediastínica (linfoma, sobre todo Hodgkin esclerosis nodular en mujer joven), etapificación inicial, fiebre en neutropénico y búsqueda de tumor pulmonar.
- Ensanchamiento del mediastino por masa mediastínica anterior: sugiere linfoma (también timoma, teratoma, tiroides); una masa voluminosa (bulky) empeora el pronóstico y obliga a cautela con la sedación por riesgo de compresión de vía aérea.
- Masa central perihiliar en fumador: carcinoma epidermoide o microcítico; periférico: adenocarcinoma. Puede asociar síndrome de vena cava superior.
- Neumonía por Pneumocystis: infiltrado intersticial bilateral perihiliar en alas de mariposa; en el neutropénico los infiltrados pueden estar ausentes.
- Lesiones líticas costales en mieloma; derrame pleural o atelectasia por tumor.
- Los hallazgos orientan, pero el diagnóstico de linfoma o cáncer requiere TAC y biopsia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 22 años con fiebre vespertina, sudoración nocturna, prurito y baja de peso de 3 meses. Al examen presenta adenopatías supraclaviculares indoloras, de consistencia gomosa. Se solicita radiografía de tórax. **¿Cuál es el hallazgo radiológico más esperable?**

A Ensanchamiento del mediastino por masa mediastínica anterior

B Cavitación en el lóbulo superior derecho

C Patrón intersticial reticular basal bilateral

D Nódulo pulmonar periférico calcificado

E Neumotórax espontáneo

Respuesta A. Una mujer joven con síntomas B, prurito y adenopatías supraclaviculares orienta a linfoma de Hodgkin esclerosis nodular, que con frecuencia presenta masa mediastínica anterior, vista como ensanchamiento del mediastino. Una masa voluminosa empeora el pronóstico y debe evaluarse antes de sedar por riesgo de compresión de la vía aérea. El diagnóstico requiere biopsia excisional del ganglio.

▶ VER CLASE 1.08.4.002 Cintigrafía ósea y cintigrafía con galio

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.8 · Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason

QUÉ HAY QUE SABER

- Cintigrafía ósea (tecnecio-99m): muy sensible para metástasis óseas osteoblásticas; estudio de extensión en cáncer de próstata de alto riesgo (APE >20 o Gleason ≥8) y de mama, y ante dolor óseo en paciente oncológico.
- Hallazgo: focos múltiples de hipercaptación en esqueleto axial (columna, pelvis, costillas) sugieren metástasis; es poco específica (fracturas, artrosis, infección también captan).
- En el mieloma múltiple la cintigrafía ósea puede ser normal (lesiones puramente líticas): se prefieren radiografías, TAC de baja dosis o RM.
- Cintigrafía con galio-67: capta en procesos inflamatorios, infecciosos y en linfomas; hoy reemplazada en gran parte por el PET-CT.
- La radiografía es poco sensible para metástasis tempranas y la densitometría mide masa ósea, no extensión tumoral.
- El médico general emplea el informe: confirma o descarta compromiso óseo para derivar y planificar tratamiento.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años con antígeno prostático específico de 62 ng/mL y biopsia prostática con adenocarcinoma Gleason 8 (4+4). Refiere dolor lumbar leve. **¿Cuál es el examen más adecuado para el estudio de extensión ósea?**

A Radiografía de columna lumbar

B Cintigrafía ósea

C Densitometría ósea

D Cintigrafía con galio

E No requiere estudio de extensión

Respuesta B. En cáncer de próstata de alto riesgo (APE mayor de 20 o Gleason 8 o más) se estudia la extensión ósea con cintigrafía ósea, muy sensible para metástasis osteoblásticas, junto con TAC de abdomen y pelvis o PET-PSMA. La radiografía es poco sensible y la densitometría mide masa ósea. La cintigrafía con galio se usa en linfomas e infecciones.

▶ VER CLASE 1.08.4.003 Biopsia de médula ósea

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.5 · Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: confirmar aplasia medular, mielofibrosis (aspirado seco), infiltración medular (síndrome leucoeritroblástico, metástasis, linfoma), mielodisplasia y mieloma; también estudio de pancitopenia sin causa clara.
- Aplasia: celularidad <25 % con reemplazo graso, sin blastos ni fibrosis ni tumor.
- Mielofibrosis: fibrosis reticulínica/colágena con megacariocitos atípicos; la biopsia es obligatoria porque el aspirado sale seco.
- Mieloma: plasmocitos clonales ≥10 %; leucemia aguda: ≥20 % de blastos (habitualmente en el mielograma, complementado con biopsia).
- A diferencia del mielograma (citología), la biopsia evalúa celularidad, arquitectura, fibrosis e infiltración; se toma de la cresta ilíaca posterior.
- El médico general emplea el informe; antes de pedirla descartar causas simples de citopenia (B12, folato, hiperesplenismo).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 171

Paciente con dolores óseos, anemia normocítica, VHS mayor de 90 mm/h y creatinina elevada. **¿Cuál es el estudio para confirmar el diagnóstico?**

A Proteína de Bence-Jones en orina

B Electroforesis de proteínas séricas

C TAC de cuerpo completo de dosis baja

D Biopsia ósea de una lesión lítica

E Aspirado y biopsia de médula ósea con estudio citogenético

Respuesta E. Dolor óseo, anemia, VHS muy alta y falla renal orientan a mieloma múltiple. La electroforesis y la proteína de Bence-Jones detectan el componente monoclonal, pero la confirmación exige demostrar plasmocitos clonales (≥ 10 %) en el aspirado y biopsia de médula ósea, que además aporta la citogenética pronóstica.

▶ VER CLASE 1.08.4.004 Electroforesis de proteínas

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.19 · Mieloma Múltiple: Criterios CRAB, Pico Monoclonal, Gammapatía Monoclonal Incierta (GMSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: sospecha de gammapatía monoclonal (adulto mayor con dolor óseo, anemia, falla renal, hipercalcemia, VHS >100) y estudio de hipoalbuminemia o hipergammaglobulinemia.
- Pico monoclonal: espícula angosta de base estrecha, habitualmente en la zona gamma; se tipifica con inmunofijación (IgG 55 %, IgA 20 %, cadenas ligeras 20 %).
- Hipergammaglobulinemia policlonal (base ancha): inflamación crónica, cirrosis, infecciones crónicas, autoinmunidad.

- Electroforesis normal no descarta mieloma de cadenas ligeras: pedir cadenas ligeras libres en suero (kappa/lambda) y orina de 24 h (Bence-Jones).
- Interpretación: componente M <3 g/dL sin CRAB y plasmocitos <10 % = GMSI (control anual); ≥3 g/dL o con CRAB orienta a mieloma: derivar.
- Otros patrones: hipoalbuminemia (síndrome nefrótico, desnutrición), hipogammaglobulinemia (LLC, inmunodeficiencias).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 133

Paciente de 78 años consulta por lumbago de 1 mes de evolución, progresivo e intenso, que no ha respondido a analgésicos. Examen físico: IMC 20, FC 75 lpm, PA 126/86 mmHg; cabeza, cuello y examen cardiopulmonar normales; columna lumbar con limitación de los movimientos por dolor. Exámenes: hematocrito 30 %, hemoglobina 10,5 g/dL, plaquetas 88.000/mm³, leucocitos 4.300/mm³ con fórmula normal, VHS 78 mm/h, creatinina 2,2 mg/dL, natremia 135 mEq/L, calcemia 10,5 mg/dL, proteínas totales 8,9 g/dL y albúmina 2,9 g/dL. **¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A Electroforesis de proteínas en sangre
B Densitometría ósea
C Radiografía de huesos largos y cráneo
D Estudio citogenético de médula ósea
E Niveles plasmáticos de vitamina B12

Respuesta A. Lumbago progresivo en un adulto mayor con anemia, VHS alta, falla renal, calcio en el límite alto y una brecha de 6 g/dL entre proteínas totales y albúmina: sospecha de mieloma múltiple. La electroforesis de proteínas demuestra el componente monoclonal y es el examen indicado; luego se completa el estudio con médula ósea e inmunofijación.

▶ VER CLASE **1.08.4.005** **Estudio de coagulopatías** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Hematología 8.11 · Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno
Hematología 8.13 · Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

QUÉ HAY QUE SABER

- Primero mirar cómo sangra: petequias y mucosas = hemostasia primaria (plaquetas, von Willebrand); hemartrosis y hematomas profundos = factores de coagulación.
- TP/INR: vía extrínseca y común (VII, X, V, II, fibrinógeno); normal 11–13,5 s, INR 0,8–1,2. TP largo aislado: cumarínicos, déficit inicial de vitamina K, hepatopatía leve.
- TTPK: vía intrínseca (XII, XI, IX, VIII) y común, normal 25–35 s; largo aislado: hemofilia A o B, von Willebrand, heparina, anticoagulante lúpico. Monitoriza heparina no fraccionada (1,5–2,5 veces).
- Prueba de mezcla 1:1: si corrige, déficit de factor (dosificar VIII, IX, XI); si no corrige, inhibidor (anticoagulante lúpico o anti-VIII).
- TP y TTPK largos: daño hepático grave (factor V bajo), CID (con plaquetas y fibrinógeno bajos, dímero D alto), déficit masivo de vitamina K o anticoagulantes directos.
- Plaquetas bajas con TP y TTPK normales: PTI, hiperesplenismo o falla medular; descartar pseudotrombocitopenia por EDTA en frotis.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 78

Una niña de 15 años presenta hipermenorrea y menometrorragia de larga data. Se solicita un hemograma, que muestra hemoglobina: 9g/dl, hematocrito: 27%, blancos: 6.000 por mm3 y plaquetas: 240.000 por mm3. Su ecografía ginecológica es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?**

A Resonancia magnética de pelvis
B Prueba de progesterona
C Biopsia de endometrio
D Estudio de trombofilias
E Estudio de hemostasia

Respuesta E. Adolescente con sangrado menstrual abundante de larga data y ecografía normal: se estudia la hemostasia (plaquetas, TP, TTPK y luego estudio de von Willebrand). La trombofilia es el estudio de quien trombosa, no de quien sangra.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 28

Paciente de 20 años que desde los 7 años presenta epistaxis frecuentes y equimosis ante pequeños traumatismos; desde su menarquia a los 14 años tiene sangrados menstruales abundantes. Hemograma: hematocrito 45 %, VCM 90 fL, leucocitos 6.000/mm³, plaquetas 250.000/mm³. TTPK normal, protrombinemia 85 % y tiempo de sangría mayor de 8 minutos. **¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio en este caso?**

A Mielograma
B Citometría de flujo para el receptor plaquetario IIb/IIIa
C Estudio de enfermedad de von Willebrand
D Niveles plasmáticos de factor VIII y factor IX de la coagulación
E Electroforesis de proteínas en sangre

Respuesta C. Sangrado mucocutáneo desde la infancia con plaquetas normales y tiempo de sangría prolongado: alteración de la hemostasia primaria. La causa hereditaria más frecuente es la enfermedad de von Willebrand; se estudia con factor von Willebrand antigénico, su actividad y factor VIII. Un TTPK normal no la descarta.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 22 años, sin antecedentes de sangrado ni cirugías, programado para una cirugía electiva. Exámenes: Hb 14,2 g/dL, plaquetas 245.000/µL, TP 12,2 s (INR 1,05), TTPK 58 s (control 30 s). La mezcla 1:1 con plasma normal corrige el TTPK a 31 s. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Operar sin cambios: nunca ha sangrado

B Solicitar anticoagulante lúpico y anticuerpos antifosfolípidos

C Diferir la cirugía y dosificar factores VIII, IX y XI

D Administrar vitamina K y repetir el TP

E Transfundir plaquetas antes de la cirugía

Respuesta C. TTPK prolongado aislado que corrige con la mezcla: déficit de un factor de la vía intrínseca, no un inhibidor. Se difiere la cirugía no urgente y se dosifican VIII, IX y XI para diagnosticar una hemofilia leve asintomática. La vitamina K corrige el TP, que aquí es normal.

▶ VER CLASE 1.08.4.006 Estudio de trombofilia

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.23 · Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado en TEV no provocado en menor de 50 años, trombosis recurrentes, sitios atípicos (venas cerebrales, mesentéricas, suprahepáticas), antecedente familiar directo de TEV precoz y morbilidad obstétrica sugerente de SAF. No en trombosis provocada.
- Panel: factor V Leiden y protrombina G20210A (PCR genética), proteína C, proteína S y antitrombina (funcionales), y anticuerpos antifosfolípidos (anticoagulante lúpico, anticardiolipina, anti-β2-glicoproteína I).
- Las pruebas genéticas se pueden hacer en cualquier momento, aun anticoagulado.
- Proteína C, S y antitrombina se alteran en fase aguda, con heparina (baja antitrombina) y cumarínicos (bajan C y S): medir 4–6 semanas después de suspender.
- SAF: anticuerpos positivos en 2 ocasiones separadas por al menos 12 semanas; el anticoagulante lúpico prolonga el TTPK y no corrige con la mezcla.
- El médico general emplea el informe: un resultado positivo cambia la duración de la anticoagulación y el tipo de anticoagulante (SAF: cumarínico).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 25 años con trombosis venosa profunda poplítea izquierda no provocada, confirmada por eco-Doppler. No usa anticonceptivos ni ha tenido cirugías, viajes o inmovilización. Su madre tuvo una embolia pulmonar a los 38 años. Se inicia enoxaparina y se planifica el estudio de trombofilia. **Respecto del estudio de trombofilia, ¿cuál es la afirmación correcta?**

A Se debe medir proteína C, proteína S y antitrombina hoy, antes de la primera dosis de heparina

B Las pruebas genéticas de factor V Leiden y mutación G20210A de la protrombina pueden realizarse en cualquier momento, aun con anticoagulación

C El estudio está indicado en todo paciente con una primera trombosis provocada por cirugía

D Las proteínas C y S se miden de forma confiable durante el tratamiento con acenocumarol

E El anticoagulante lúpico se interpreta de forma confiable durante la infusión de heparina

Respuesta B. Las mutaciones (factor V Leiden, protrombina G20210A) se estudian por ADN y no se alteran con la trombosis ni con anticoagulantes. En cambio, proteína C, S y antitrombina se consumen en la fase aguda, la heparina baja la antitrombina y los cumarínicos bajan C y S: se miden lejos del evento y sin esos fármacos.

▶ VER CLASE 1.08.4.007 Estudio de trombopatías

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.11 · Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar trombopatía ante sangrado mucocutáneo (epistaxis, gingivorragia, menorragia) con recuento plaquetario, TP y TTPK normales.
- Primero descartar causa farmacológica (aspirina, AINE, clopidogrel) y enfermedad de von Willebrand (antígeno, cofactor de ristocetina y factor VIII).
- Recuento y frotis: confirmar número real de plaquetas (descartar pseudotrombocitopenia por EDTA) y tamaño (plaquetas gigantes en Bernard-Soulier).
- Estudio de función: agregometría plaquetaria con ADP, colágeno, epinefrina y ristocetina, suspendiendo antes los fármacos antiplaquetarios.
- Patrones: Glanzmann (falta GP IIb/IIIa: no agrega con ADP/colágeno, sí con ristocetina); Bernard-Soulier (falta GP Ib: no agrega con ristocetina, plaquetas gigantes).
- Adquiridas: uremia, antiagregantes, hepatopatía, mieloproliferativos; derivar a hematología si el estudio básico no explica el sangrado.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 27 años con epistaxis recurrentes desde la infancia, gingivorragia al cepillarse y menstruaciones abundantes. No usa AINE ni antiagregantes. Hemograma normal con plaquetas 260.000/µL y frotis sin plaquetas gigantes. TP 12 s, TTPK 30 s, fibrinógeno 310 mg/dL. Factor von Willebrand antigénico y actividad normales, factor VIII 95 %. **¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?**

A Mielograma

B Tiempo de trombina

C Anticuerpos antiplaquetarios

D Estudio de agregación plaquetaria (agregometría) con distintos agonistas

E Dosificación de factores IX y XI

Respuesta D. Sangrado mucocutáneo con recuento plaquetario, coagulación y estudio de von Willebrand normales: sospecha de trombopatía (defecto de función plaquetaria). Se estudia con agregometría frente a ADP, colágeno, epinefrina y ristocetina, previa suspensión de fármacos que alteran la función plaquetaria. Mielograma y anticuerpos son para trombocitopenias.

▶ VER CLASE 1.08.4.008 Hemograma

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Hematología 8.1 · Síndrome Anémico: Definición, Índices Eritrocitarios (VCM, HCM) e Índice Reticulocitario

Psiquiatría 17.11 · Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma

QUÉ HAY QUE SABER

- Anemia según OMS: Hb <13 g/dL en hombre, <12 en mujer, <11 en embarazo (manda la Hb, no el hematocrito; Hto ≈ 3 × Hb).
- VCM (80–100 fL) clasifica: microcítica (ferropenia, talasemia), normocítica (inflamación, ERC, hemorragia aguda, hemólisis) y macrocítica (B12/folato, alcohol, hepatopatía, hipotiroidismo).
- RDW >15 % sugiere ferropenia; RDW normal con microcitosis marcada y GR altos (Mentzer <13) sugiere rasgo talasémico. HCM <27 pg = hipocromía.
- Reticulocitos corregidos: IRC >2 % regenerativa (hemólisis, hemorragia aguda); <2 % arregenerativa (carencias, aplasia, inflamación, ERC).
- Serie blanca: calcular RAN (leucocitos × % neutrófilos); neutropenia grave <500. Leucocitosis con blastos: leucemia aguda; con toda la serie y basofilia: LMC; linfocitosis madura en anciano: LLC.
- Plaquetas normales 150.000–450.000; trombocitopenia confirmar con frotis; trombocitosis reactiva en ferropenia. Pancitopenia sin bazo: aplasia; con bazo: hiperesplenismo o infiltración. Monitoreo obligatorio con clozapina.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 168

Paciente con cáncer de mama en quimioterapia hace 9 días, hace 3 días comienza con fiebre. **¿Cuál es el examen inicial para iniciar estudio?**

A Hemograma

B Hemocultivos periféricos x2

C TAC de tórax-abdomen-pelvis

D PCR y procalcitonina

E Uroanálisis y urocultivo

Respuesta A. La neutropenia febril se define por fiebre más un RAN < 500/mm³. El hemograma es el examen inicial: sin el recuento de neutrófilos no hay diagnóstico ni estratificación.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 28 años con esquizofrenia ha recibido tratamiento con haloperidol 10 mg/día durante 8 semanas y posteriormente con risperidona 6 mg/día durante 8 semanas, ambas con adherencia confirmada por sus cuidadores, persistiendo con alucinaciones auditivas agresivas e ideación delirante severa que le impiden salir a la calle. Su hemograma basal muestra leucocitos 6.500/mm³ con neutrófilos en 4.200/mm³. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y el tratamiento farmacológico de elección? **¿Cuál es el diagnóstico clínico y el tratamiento farmacológico de elección?**

A Psicosis reactiva; suspender antipsicóticos e iniciar psicoterapia

B Esquizofrenia refractaria; iniciar tratamiento con clozapina bajo protocolo de monitorización hematológica

C Trastorno bipolar maníaco; iniciar monoterapia con carbamazepina

D Simulación de síntomas; dar el alta sin medicación

E Esquizofrenia simple; rotar a clorpromazina en dosis bajas

Respuesta B. Cumple criterios de esquizofrenia refractaria: falla a dos antipsicóticos distintos a dosis plena por al menos 6 semanas cada uno, uno de ellos atípico (risperidona), con adherencia confirmada. Su hemograma basal es normal (leucocitos mayores de 3.500 y RAN mayor de 2.000), por lo que se inicia clozapina bajo el protocolo de farmacovigilancia hematológica (hemograma semanal los primeros 6 meses).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 34 años con esquizofrenia refractaria en tratamiento con clozapina 300 mg/día acude a su control en la semana 10 de terapia. Su hemograma de control protocolizado muestra leucocitos totales de 2.200/mm³ y recuento absoluto de neutrófilos (RAN) de 790/mm³. El paciente no presenta fiebre ni síntomas infecciosos. ¿Cuál es la conducta médica inmediata e ineludible? **¿Cuál es la conducta médica inmediata e ineludible?**

A Reducir la dosis de clozapina a 150 mg al día y repetir el hemograma en un mes

B Suspender de inmediato la clozapina, hospitalizar en aislamiento protector y contraindicar la reexposición de por vida

C Mantener la clozapina e indicar amoxicilina profiláctica por vía oral

D Asociar biperideno 5 mg cada 12 horas para estimular la médula ósea

E Asumir error de laboratorio, tranquilizar al paciente y mantener la dosis

Respuesta B. Agranulocitosis inducida por clozapina (RAN menor de 1.000/mm³, aquí 790). Es potencialmente mortal por sepsis neutropénica. Conducta: suspensión inmediata y definitiva, hospitalización en aislamiento protector, evaluación hematológica para eventual G-CSF (filgrastim) y registro de la contraindicación de reexposición de por vida. Reducir la dosis o esperar expone a sepsis y muerte. El biperideno no tiene acción sobre la médula ósea.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 72 años, autovalente, consulta en CESFAM por astenia y palidez progresiva de 3 meses. Niega melena o hematuria. Hemograma: Hb 8,8 g/dL, Hto 27 %, VCM 74 fL, HCM 24 pg, leucocitos 6.100/µL, plaquetas 420.000/µL, reticulocitos 0,6 %. Soplo sistólico eyectivo II/VI aórtico, sin taquicardia ni insuficiencia cardíaca. **¿Cuál es la interpretación y la conducta más adecuada?**

A Anemia regenerativa; solicitar LDH, bilirrubina y Coombs directo

B Anemia microcítica arregenerativa; perfil de hierro y estudio endoscópico alto y bajo

C Anemia microcítica; iniciar sulfato ferroso y controlar hemograma en 3 meses

D Anemia normocítica; solicitar biopsia de médula ósea

E Anemia grave; transfundir glóbulos rojos

Respuesta B. VCM 74 y HCM 24: microcítica hipocrómica. IRC = 0,6 × (27/45) ÷ 1,5 ≈ 0,24 %: arregenerativa. Con trombocitosis reactiva, la sospecha es ferropenia por sangrado digestivo oculto: perfil de hierro inmediato y endoscopía digestiva alta más colonoscopía. Sin inestabilidad, no se transfunde.

▶ VER CLASE 1.08.4.009 Mielograma

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.16 · Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

QUÉ HAY QUE SABER

- Mielograma: aspirado de médula ósea para estudio citológico (habitualmente de cresta ilíaca o esternón).
- Indicación principal: confirmar leucemia aguda (≥20 % de blastos) y clasificarla con citometría de flujo (mieloide vs linfoide), citogenética y biología molecular.
- También útil en mieloma (plasmocitos ≥10 %), mielodisplasia (displasia, porcentaje de blastos) y estudio de citopenias inexplicadas.
- Limitación: no evalúa celularidad ni fibrosis; aspirado seco o hipocelular (aplasia, mielofibrosis, infiltración) obliga a biopsia de médula ósea.
- Antes de pedirlo, el hemograma con frotis orienta (blastos en sangre periférica = derivación urgente).
- El médico general emplea el informe y deriva; no se requiere para diagnosticar ferropenia ni déficit de B12.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 24

Un niño de 8 años presenta dolores óseos, asociados a malestar general y fiebre de 3 semanas de evolución. Al examen físico se palpa el bazo aumentado de tamaño, por 3 cm bajo el reborde costal de consistencia indurada, se constatan poliadenopatías indoloras y se observan petequias y equimosis generalizadas, mayores en las extremidades inferiores **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?**

A Cintigrafía ósea

B Hemograma

C Biopsia esplénica

D Electroforesis de proteínas en sangre

E Mielograma

Respuesta E. Niño con dolores óseos, fiebre, esplenomegalia, adenopatías y púrpura: leucemia aguda, probablemente LLA. El hemograma inicia el estudio, pero lo que confirma es el mielograma (o la biopsia de médula ósea) con 20% o más de blastos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 117

Un hombre de 80 años, diabético, consulta por dolor intenso en la zona costal derecha, que aumenta con la palpación y movimientos. Al examen físico tiene dolor epicrítico al palpar la zona. En sus exámenes destaca hemograma con hematocrito: 27%, plaquetas: 103.000 por mm3, blancos: 5.000 por mm3, VHS: 90 mmHg. Además, trae creatininemia: 2,1 mg/dl, calcio: 10,8 mg/dl, proteínas: 9,1 g/dl y albúmina plasmática: 3,0 g/dl. La ecografía abdominal muestra riñones de tamaño normal. **¿Cuál es el examen de elección para la confirmación diagnóstica?**

A Beta2 microglobulina
B Resonancia magnética de columna
C Radiografía de parrilla costal
D Mielograma
E Biopsia renal

Respuesta D. Dolor costal (probable fractura patológica), anemia, VHS alta, falla renal con riñones de tamaño normal y proteínas totales altas con albúmina baja (exceso de globulinas): mieloma múltiple. Se confirma en la médula ósea (mielograma) con 10% o más de plasmocitos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 112

Un paciente de 75 años presenta un cuadro de dolor lumbar de 3 meses de evolución, asociado a pérdida de peso y astenia. En sus exámenes tiene hemograma con hemoglobina: 9,2 g/dl, Plauqetas: 92.000 por mm3, blancos: 5000 por mm3, VHS:103 mm/h, creatinina: 1,7 mg/dl, albúmina: 3,2 g/dl, proteínas plasmáticas: 9,8 g/dl. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar la sospecha diagnóstica?

A Radiografía de huesos largos
B Radiografía de cráneo
C Recuento de inmunoglobulinas
D Mielograma
E Calcemia

Respuesta D. Es un mieloma, que se diagnostica con mielograma o biopsia de médula ósea (el mielograma equivale al frotis de médula ósea).

▶ VER CLASE 1.08.4.010 Pruebas de hemólisis

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Hematología 8.7 · Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI: Anticuerpos Calientes IgG vs Crioaglutininas IgM) y Test de Coombs Directo
Hematología 8.8 · Esferocitosis Hereditaria, Déficit de G6PD (Favismo) y Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN)

QUÉ HAY QUE SABER

- Pilares de hemólisis: reticulocitos altos (IRC >2 %), LDH elevada, bilirrubina indirecta 2–5 mg/dL y haptoglobina <10 mg/dL.
- Intravascular (ABO, HPN, microangiopatía, crioaglutininas): hemoglobinuria y hemosiderinuria; extravascular (AHAI caliente, esferocitosis): esplenomegalia.
- Coombs directo: IgG ± C3d = AHAI caliente; solo C3d = crioaglutininas; negativo = defecto del glóbulo o mecánico. Coombs indirecto: anticuerpos libres en el suero.
- Frotis: microesferocitos (AHAI, esferocitosis), esquistocitos (PTT, SHU, CID), cuerpos de Heinz y células mordidas (G6PD), drepanocitos.
- Confirmatorios específicos: fragilidad osmótica (esferocitosis), G6PD cuantitativa 2–3 meses después de la crisis, citometría CD55/CD59 (HPN), electroforesis de hemoglobina.
- Trampa: la megaloblástica también eleva LDH y bilirrubina indirecta pero con reticulocitos bajos (hemólisis intramedular).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 52

Una mujer de 40 años consulta por astenia, asociada a adinamia y disnea de medianos esfuerzos progresivas, desde hace una semana. Al examen físico tiene palidez de piel y mucosas. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 24%, hemoglobina: 8 mg/dl, VCM elevado; glóbulos blancos: 9.800 por mm3, plaquetas: 160.000 por mm3. El frotis sanguíneo demuestra macrocitosis y policromasia. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A Prueba de Coombs
B Niveles plasmáticos de B12
C LDH y bilirrubina directa
D Recuento de reticulocitos
E Biopsia de médula ósea

Respuesta A. Anemia de instalación en una semana con macrocitosis y policromasia (reticulocitos jóvenes) y resto del hemograma normal: anemia hemolítica, probablemente autoinmune. El examen que confirma el diagnóstico etiológico es la prueba de Coombs directa.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Joven de 17 años con dolor cólico posprandial en hipocondrio derecho e ictericia fluctuante. Ecografía: colelitiasis múltiple y esplenomegalia moderada. Su padre fue colecistectomizado a los 22 años y esplenectomizado. Hb 10,2 g/dL, VCM 79 fL, CHCM 37,2 g/dL, reticulocitos 7,5 %, bilirrubina indirecta 3,2 mg/dL, LDH 520 UI/L. Frotis: abundantes microesferocitos. Coombs directo negativo. **¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico más probable?**

A Prueba de fragilidad osmótica eritrocitaria

B Dosificación cuantitativa de G6PD

C Citometría de flujo para CD55 y CD59

D Electroforesis de hemoglobina

E Biopsia de médula ósea

Respuesta A. Hemólisis con Coombs negativo, microesferocitos, CHCM > 36, colelitiasis juvenil, esplenomegalia y padre afectado (autosómica dominante): esferocitosis hereditaria. Se confirma con fragilidad osmótica. Luego: vacunas contra encapsulados, esplenectomía electiva y colecistectomía.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

8 códigos

▶ VER CLASE 1.08.5.001 **Biopsia de médula ósea** NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.5 · Aplasia Medular e Hipofunción Medular Adquirida vs Fármacos Mielotóxicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Procedimiento del especialista (hematólogo): punción-biopsia de cresta ilíaca posterior con trocar, bajo anestesia local.
- Indicaciones para derivar: pancitopenia sin causa clara (sospecha de aplasia), aspirado seco, síndrome leucoeritroblástico, sospecha de mielofibrosis, infiltración por linfoma o metástasis, mieloma y mielodisplasia.
- Aporta celularidad, arquitectura, fibrosis e infiltración (el aspirado solo da citología).
- Antes de derivar: hemograma con frotis, reticulocitos, B12, folato, perfil hepático y descartar hiperesplenismo y fármacos mielotóxicos.
- Complicaciones poco frecuentes: dolor, hematoma, sangrado e infección local; las trombocitopenias rara vez la contraindican.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 28 años con pancitopenia: hemoglobina 7,1 g/dL, leucocitos 1.500/mm3 con 400 neutrófilos/mm3, plaquetas 12.000/mm3 y reticulocitos 0,2%. Sin esplenomegalia ni adenopatías. El aspirado de médula ósea es escaso, con muy pocas células (punción seca). **¿Cuál es el examen que permite confirmar el diagnóstico más probable?**

A Repetir el aspirado en 1 mes

B TAC de tórax

C Electroforesis de hemoglobina

D Test de Coombs directo

E Biopsia de médula ósea

Respuesta E. Pancitopenia con reticulocitos bajos, sin visceromegalias y aspirado hipocelular sugiere aplasia medular. El aspirado no permite evaluar la celularidad ni la fibrosis; la biopsia de médula ósea es indispensable para confirmar la hipocelularidad (menor de 25%) y descartar infiltración o mielofibrosis, que también producen punción seca.

▶ VER CLASE 1.08.5.002 **Biopsia ganglionar** NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.18 · Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicar ante adenopatía sospechosa: >2 cm, indolora, gomosa o pétrea, persistente >4–6 semanas, supraclavicular, o con síntomas B; la realiza el cirujano (derivar).
- Técnica de elección: biopsia escisional del ganglio completo, que permite ver la arquitectura y clasificar el linfoma (Reed-Sternberg en Hodgkin).
- Si el ganglio es profundo o inaccesible: biopsia con aguja gruesa (trucut) guiada por imágenes.
- La PAAF no sirve para diagnosticar linfoma (solo células sueltas); puede usarse en sospecha de metástasis de carcinoma.
- Elegir el ganglio más grande y representativo (supraclavicular, cervical o axilar mejor que inguinal); no iniciar corticoides antes de la biopsia porque enmascaran el diagnóstico.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 25 años con aumento de volumen cervical izquierdo de 2 meses, indoloro y de crecimiento paulatino. En el último mes, sudoración nocturna que empapa su camiseta y baja involuntaria de 7 kg (peso basal 68 kg). Conglomerado adenopático supraclavicular y cervical lateral izquierdo de 4 cm, gomoso, móvil, no sensible. Sin otras adenopatías ni visceromegalias. El médico general sospecha tuberculosis y solicita una PAAF. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar la PAAF y esperar el resultado citológico

B Iniciar tratamiento antituberculoso empírico

C Suspender la PAAF y derivar para biopsia escisional del ganglio completo

D Indicar antibióticos por 2 semanas y reevaluar

E Iniciar ABVD por sospecha de linfoma de Hodgkin

Respuesta C. Adulto joven con adenopatía supraclavicular gomosa persistente y síntomas B (sudoración nocturna y baja de peso > 10%): sospecha de linfoma de Hodgkin. La PAAF no evalúa la arquitectura ni permite tipificar el linfoma. Se suspende y se deriva para biopsia escisional (Reed-Sternberg) y etapificación, con cobertura GES 38. No se trata sin confirmación histológica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 37

Un hombre de 30 años presenta aumento de volumen en el cuello, desde hace dos meses, que ha progresado desde ese entonces. Además, ha presentado sudoración nocturna y fiebre ocasional. Al examen físico, tiene signos vitales normales y se constata presencia de una adenopatía de 3 x 2 cm, ubicada en el triángulo anterior del cuello. Su examen cardiopulmonar no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada para confirmar el diagnóstico?

A Hemograma VHS

B Biopsia de médula ósea

C Serología para citomegalovirus

D Biopsia ganglionar

E Serología para virus de Epstein Barr

Respuesta D. Linfoma de Hodgkin: La sospecha clínica es un linfoma de Hodgkin, debido a la presencia de síntomas B y la adenopatía. El diagnóstico se confirma mediante biopsia excisional de uno de los ganglios.

▶ VER CLASE 1.08.5.003 Biopsia hepática

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.4 · Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares

QUÉ HAY QUE SABER

- Procedimiento del especialista; percutánea guiada por ecografía o transyugular si hay coagulopatía o ascitis.
- Indicaciones: hepatopatía de causa no aclarada, etapificar fibrosis cuando no hay métodos no invasivos, lesión focal con imagen atípica o en hígado no cirrótico.
- En cirrótico con nódulo >1 cm con hiperrealce arterial y lavado portal/tardío en TAC o RM trifásica, el hepatocarcinoma se diagnostica sin biopsia (riesgo de sangrado y siembra).
- Contraindicaciones relativas: plaquetas <50.000, INR prolongado, ascitis a tensión, sospecha de quiste hidatídico (nunca puncionar) o hemangioma.
- Antes del procedimiento: corregir plaquetas (transfundir si <50.000) y coagulación; complicación principal: hemorragia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 63 años con cirrosis por virus hepatitis C, en seguimiento con ecografía semestral, presenta un nódulo hepático de 3 cm. En la TAC trifásica la lesión muestra hiperrealce en fase arterial y lavado en fases portal y tardía. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto del diagnóstico?**

A Biopsia hepática percutánea obligatoria antes de tratar

B Control con ecografía en 6 meses

C Diagnóstico de carcinoma hepatocelular sin necesidad de biopsia y derivar para tratamiento

D Medir CA 19-9 para confirmar

E Biopsia transyugular

Respuesta C. En un cirrótico, un nódulo mayor de 1 cm con hiperrealce arterial y lavado en fase portal o tardía en TAC o RM permite diagnosticar carcinoma hepatocelular sin biopsia. La biopsia se reserva para lesiones con imagen atípica o hígado no cirrótico, por su riesgo de sangrado y siembra tumoral. El CA 19-9 se usa en colangiocarcinoma.

▶ VER CLASE 1.08.5.004 Cateterismo venoso central

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 2.3 · IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: drogas vasoactivas, nutrición parenteral, quimioterapia, accesos venosos difíciles, hemodiálisis; lo instala el especialista con técnica aséptica completa y guía ecográfica.
- Tras instalar un CVC yugular o subclavio: radiografía de tórax antes de usarlo, para verificar la punta en vena cava superior y descartar neumotórax (mayor riesgo en subclavia).
- Complicaciones: neumotórax, punción arterial, hematoma, arritmias, embolia gaseosa, trombosis e infección.

- Bacteriemia por catéter: hemocultivos pareados (periférico + cada lumen); CVC positivo >2 h antes que el periférico o razón ≥3:1. Gérmenes: S. epidermidis, S. aureus, BGN, Candida.
- Retiro obligatorio si shock, túnel infectado, complicación metastásica, S. aureus, Candida o Pseudomonas, o bacteriemia persistente a 48–72 h; tratamiento empírico con vancomicina.
- No se recomiendan antibiótico profiláctico ni recambio programado; la prevención es técnica aséptica y retiro oportuno.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Paciente de 55 años en UCI requiere un catéter venoso central para drogas vasoactivas. Se instala por vía yugular interna derecha guiado por ecografía, con técnica estéril completa. **¿Qué debe hacerse antes de usarlo para la infusión de drogas vasoactivas?**

A Hemocultivo a través del catéter

B Antibiótico profiláctico

C Cambio del catéter a las 72 horas

D Radiografía de tórax para confirmar la posición de la punta y descartar neumotórax

E TAC de cuello

Respuesta D. Tras instalar un catéter venoso central yugular o subclavio, la radiografía de tórax confirma que la punta esté en la vena cava superior, cerca de su unión con la aurícula derecha, y descarta neumotórax. No se recomiendan antibiótico profiláctico ni recambio programado: la prevención de infección se basa en técnica aséptica y retiro oportuno.

▶ VER CLASE 1.08.5.005 Mielograma

NIVEL **DERIVAR A ESPECIALISTA**

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.16 · Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

QUÉ HAY QUE SABER

- Procedimiento del especialista: aspirado de médula ósea de cresta ilíaca (o esternón en adultos).
- Indicación para derivar: sospecha de leucemia aguda (blastos en sangre periférica, insuficiencia medular de semanas), mieloma, mielodisplasia o citopenias sin explicación.
- Confirma leucemia aguda con ≥20 % de blastos y se complementa con citometría de flujo, citogenética y biología molecular.
- En el niño con sospecha de LLA, el mielograma con inmunofenotipo es el examen de elección; la punción lumbar se hace después para evaluar SNC.
- Si el aspirado es seco o hipocelular, el especialista complementa con biopsia de médula ósea.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 4 años con palidez, fiebre, petequias y dolor óseo de 3 semanas. Hemoglobina 6,8 g/dL, leucocitos 32.000/mm3 con 60% de blastos, plaquetas 18.000/mm3. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico y clasificar la enfermedad?**

A Mielograma con inmunofenotipo por citometría de flujo

B Biopsia de ganglio linfático

C TAC de tórax, abdomen y pelvis

D Punción lumbar como primer examen

E Electroforesis de proteínas

Respuesta A. La sospecha es leucemia linfoblástica aguda, el cáncer más frecuente en la infancia. Se confirma con mielograma (aspirado de médula ósea) con 20% o más de blastos, complementado con inmunofenotipo por citometría de flujo y citogenética para clasificar y estratificar el riesgo. La punción lumbar se hace después, para evaluar compromiso del SNC.

▶ VER CLASE 1.08.5.006 Punción lumbar

NIVEL **REALIZAR**

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.2 · Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: sospecha de meningitis o encefalitis, hemorragia subaracnoidea con TAC normal, estudio de enfermedades neurológicas y administración de fármacos intratecales; la realiza el médico general.
- Hacer TAC antes de puncionar si hay déficit focal, convulsión reciente, Glasgow <10, papiledema o inmunodepresión; pero hemocultivos, dexametasona y antibióticos van primero, sin esperar la imagen.
- Contraindicaciones: hipertensión endocraneana con efecto de masa, infección en el sitio de punción, coagulopatía o plaquetas <50.000 (transfundir antes).
- Técnica: paciente en decúbito lateral o sentado, espacio L3-L4 o L4-L5 (línea de las crestas ilíacas), asepsia, medir presión de apertura (normal 10–20 cm H2O).
- LCR: bacteriana con PMN >80 %, glucosa LCR/suero <0,4 y proteínas >100; viral con mononucleares y glucosa normal; TBC/hongos con mononucleares y glucosa muy baja.
- Complicación más frecuente: cefalea pospunción (empeora de pie); usar agujas finas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años con fiebre, cefalea y rigidez de nuca de 12 horas. Al examen presenta paresia braquiocrural izquierda y papiledema. Glasgow 14. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Punción lumbar inmediata y luego antibióticos según el Gram

B Hemocultivos, dexametasona y antibióticos empíricos inmediatos, y luego TAC de cerebro antes de la punción lumbar

C TAC de cerebro y esperar el resultado para iniciar antibióticos

D Resonancia magnética y punción lumbar al día siguiente

E Punción lumbar sin TAC porque el Glasgow es mayor de 13

Respuesta B. Ante déficit focal, papiledema, convulsiones, inmunosupresión o compromiso de conciencia se hace TAC antes de la punción lumbar por riesgo de herniación. Pero los antibióticos y la dexametasona no deben retrasarse: se toman hemocultivos y se inicia tratamiento empírico antes del TAC, porque retrasar el antibiótico aumenta la mortalidad.

▶ VER CLASE 1.08.5.007 Punción venosa

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 2.1 · Manejo de Contactos en Enfermedades Transmisibles y Accidentes Cortopunzantes

QUÉ HAY QUE SABER

- Procedimiento que realiza el médico general para toma de exámenes o instalación de vía venosa periférica; preferir venas del pliegue del codo o dorso de la mano.
- Técnica: higiene de manos y guantes, identificar al paciente, ligadura proximal, antisepsia con alcohol, punción en ángulo de 15–30° con bisel hacia arriba, soltar la ligadura antes de retirar la aguja y comprimir.
- Evitar puncionar el brazo con fístula arteriovenosa, del lado de una mastectomía con vaciamiento axilar, zonas con flebitis o infección y la extremidad con suero en curso.
- Precauciones estándar: desechar de inmediato la aguja sin reencapsular, doblar ni romper, en contenedor rígido para cortopunzantes cercano.
- Accidente cortopunzante: lavar con agua y jabón, notificar y evaluar profilaxis; si la fuente es VIH positiva o desconocida, triterapia por 28 días idealmente en 2–4 h y antes de 72 h.
- Complicaciones: hematoma, flebitis, punción arterial, síncope vasovagal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una interna de medicina realiza una punción venosa para tomar exámenes a un paciente hospitalizado. Al terminar, tiene en la mano la aguja usada. **¿Cuál es la conducta correcta para prevenir un accidente cortopunzante?**

A Reencapsular la aguja con ambas manos antes de desecharla

B Eliminarla en la bolsa de basura común

C Doblar la aguja antes de botarla

D Dejar la aguja en la bandeja para eliminarla al final del turno

E Desechar de inmediato la aguja, sin reencapsular, en un contenedor rígido para cortopunzantes cercano

Respuesta E. La principal causa de accidentes cortopunzantes es el reencapsulado y la manipulación de agujas usadas. Según las precauciones estándar, la aguja se desecha de inmediato, sin reencapsular, doblar ni romper, en un contenedor rígido ubicado cerca del punto de uso. Si ocurre una punción, se lava con agua y jabón y se notifica para evaluar profilaxis.

▶ VER CLASE 1.08.5.008 Quimioterapia intratecal

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.16 · Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

QUÉ HAY QUE SABER

- Procedimiento del especialista (hematólogo/oncólogo) mediante punción lumbar o reservorio de Ommaya.
- Indicación: profilaxis obligatoria del SNC en la LLA (santuario donde la quimioterapia sistémica penetra poco) y tratamiento de infiltración meníngea por leucemias o linfomas.
- Fármacos: metotrexato, solo o con citarabina e hidrocortisona/dexametasona.
- La vincristina es mortal por vía intratecal: se prepara y administra por separado, con doble chequeo.
- Requiere plaquetas adecuadas (≥50.000) y descartar hipertensión endocraneana antes de la punción.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niña de 7 años con leucemia linfoblástica aguda en fase de inducción. Según el protocolo, debe recibir profilaxis del sistema nervioso central. **¿Cuál es el fármaco que se administra por vía intratecal con este fin?**

A Vincristina

B Doxorrubicina

C Metotrexato

D L-asparaginasa

E Imatinib

Respuesta C. El SNC es un santuario donde la quimioterapia sistémica penetra poco, por lo que en la LLA se administra quimioterapia intratecal, principalmente metotrexato, solo o con citarabina e hidrocortisona. La vincristina es mortal por vía intratecal y solo se usa endovenosa; por eso ambos fármacos se preparan y administran por separado, con doble chequeo.

09 NEFROLOGÍA

72 CÓDIGOS

131 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	25
Situaciones clínicas de urgencia	13
Conocimientos generales	11
Exámenes e imagenología	16
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	7

Situaciones clínicas

25 códigos

▶ VER CLASE 1.09.1.001 Acidosis e hiperkalemia en Insuficiencia renal crónica

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.2 · Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en ERC G3b–G5: la menor amoniogénesis baja el bicarbonato (acidosis hiperclorémica con anion gap normal en G3–G4; anion gap elevado recién en G5).
- La hiperkalemia aparece con TFG avanzada, sobre todo con IECA/ARA-II, espironolactona, AINE, dieta rica en potasio (frutos secos, plátano, cítricos) o diálisis omitida.
- Hiperkalemia: ECG inmediato. Si hay cambios (T picudas, PR largo, QRS ancho, bradicardia) o K >6,5: gluconato de calcio 10% 10 mL IV, luego insulina regular 10 UI + glucosa y salbutamol nebulizado 10–20 mg.
- Eliminar potasio: furosemida 40–80 mg IV si orina; anúrico o dializado que omitió sesión: hemodiálisis de urgencia. Bicarbonato IV solo si pH <7,1 o HCO_3 <12.
- Ambulatorio: dieta baja en potasio, suspender AINE, revisar dosis de IECA/ARA-II (pausar si K >5,5); acidosis crónica con bicarbonato oral.
- Seguimiento: derivar a nefrología; ERC G4–G5 (TFG <30) es GES N° 1 con nefrólogo en ≤30 días.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 6

Un paciente de 66 años con antecedente de insuficiencia renal crónica, en etapa IIIB, con creatinina estable en 1,8 mg/dl y clearence de creatinina estimado de 35 ml/min. Se realiza exámenes de laboratorio que muestran sodio: 138 mEq/L, cloro: 102 mEq/L potasio: 4,8 mEq/L, bicarbonato plasmático: 16 mEq/L y anion gap: 10.
¿Cuál es la causa más probable de sus alteraciones?

A Acumulación de ácidos orgánicos
B Disminución de la producción de bicarbonato
C Cetosis
D Acumulación de ácido úrico
E Intoxicación por medicamentos

Respuesta B. Acidosis metabólica con anion gap normal en ERC etapa 3b: la menor masa renal reduce la amoniogénesis y la regeneración de bicarbonato. El AG se eleva por acumulación de ácidos orgánicos recién en la etapa terminal.

▶ VER CLASE 1.09.1.002 Acidosis metabólica

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 3.3 · Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia

QUÉ HAY QUE SABER

- Acidosis metabólica: pH <7,35 con HCO_3 <22. Leer en pasos: pH, HCO_3, compensación de Winter (pCO_2 esperada = 1,5 × HCO_3 + 8 ± 2) y anion gap.
- Anion gap = Na − (Cl + HCO_3), normal 8–12; corregir +2,5 por cada 1 g/dL de albúmina bajo 4. pCO_2 sobre lo esperado: acidosis respiratoria agregada; bajo: alcalosis respiratoria.
- AG elevado (se agregó ácido, MUDPILES): cetoacidosis, uremia, láctica (shock, metformina), salicilatos, metanol/etilenglicol (brecha osmolar >10).
- AG normal hiperclorémica (se perdió bicarbonato): diarrea (AG urinario negativo), ATR (AG urinario positivo), suero fisiológico masivo.
- Tratar la causa: fluidos e insulina en la cetoacidosis. Bicarbonato solo con pH <7,10 o HCO_3 <6–8 con inestabilidad (meta pH 7,20, no normalizar); bicarbonato o citrato oral en ATR.
- Metanol o etilenglicol: fomepizol o etanol + hemodiálisis. Seguimiento: derivar según la causa (nefrología en ATR o ERC).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 24 años con diabetes tipo 1 que suspendió la insulina hace 48 horas. Llega estuporoso, con respiración de Kussmaul (FR 34), aliento cetónico, PA 95/60 mmHg, FC 122 lpm y mucosas secas. Gases: pH 7,12, pCO2 16 mmHg, HCO3 5 mEq/L. Glicemia 480 mg/dL, Na 134, Cl 98, K 5,2 mEq/L, cetonemia 5,8 mmol/L.
¿Cuál es la conducta más adecuada respecto del trastorno ácido-base?

A Bicarbonato de sodio 2/3 molar hasta normalizar el pH
B Cristaloides isotónicos e insulina rápida en infusión a 0,1 U/kg/h
C Intubar e hiperventilar para bajar la pCO2
D Hemodiálisis de urgencia
E Fomepizol y hemodiálisis

Respuesta B. CAD severa: AG = 134 − (98 + 5) = 31. Winter: 1,5 × 5 + 8 = 15,5 ± 2 (13,5–17,5); la pCO2 de 16 es compensación pura. El tratamiento es cristaloides isotónicos e insulina 0,1 U/kg/h; la insulina frena la lipólisis y los cetoácidos se metabolizan a bicarbonato. Con pH 7,12 no se indica bicarbonato de rutina.

▶ VER CLASE 1.09.1.003 Alcalosis metabólica

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 3.4 · Alcalosis Metabólica y Trastornos Ácido-Base Mixtos

QUÉ HAY QUE SABER

- Alcalosis metabólica: pH >7,45 y HCO_3 >28; compensación esperada $\Delta pCO_2 = 0,7 \times \Delta HCO_3$ (techo de pCO_2 ~55 mmHg).
- Clínica: parestesias, Chvostek, Trousseau y tetania por calcio iónico bajo; debilidad y arritmias por hipokalemia.
- El cloro urinario es el examen clave: <20 mEq/L = sensible a cloro (vómitos, sonda nasogástrica, diuréticos previos, con hipovolemia).
- Cloro urinario >20: resistente a cloro; con HTA pensar en exceso de mineralocorticoides (Conn, Cushing, estenosis renal); con PA normal, Bartter o Gitelman.
- Tratamiento de la sensible a cloro: suero fisiológico 0,9% + KCl (sin cloro no se corrige). Resistente: espironolactona o cirugía del adenoma; Bartter/Gitelman: suplementos de K y Mg.
- Seguimiento completo por el médico general: controlar gases y electrolitos hasta corregir, y la causa (vómitos, diuréticos); derivar si resistente a cloro.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 38 años con úlcera duodenal estenosante, con 5 días de vómitos profusos tras cada ingesta, debilidad y calambres periorales. PA 95/60 mmHg con ortostatismo, FC 110 lpm, mucosas muy secas. pH 7,54, pCO2 48 mmHg, HCO3 42 mEq/L, Na 135, Cl 82, K 2,6 mEq/L. Cloro urinario: 8 mEq/L. **¿Cuál es la conducta prioritaria?**

A Espironolactona oral

B Suero fisiológico 0,9% IV con cloruro de potasio

C Suero glucosado al 5% IV

D Acetazolamida IV

E Solicitar aldosterona y renina plasmáticas

Respuesta B. Alcalosis metabólica hipoclorémica e hipokalémica por vómitos (síndrome pilórico), con cloro urinario < 20: sensible a cloro. La conducta es SF 0,9% con KCl para restaurar cloro y volemia. La espironolactona y el estudio de aldosterona corresponden a la alcalosis resistente a cloro con HTA.

▶ VER CLASE 1.09.1.004 Anemia en nefrópata

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Hematología 8.4 · Anemia de la Enfermedad Crónica / Inflamación vs Anemia en la Enfermedad Renal Crónica (EPO y Manejo)
Nefrología 5.2 · Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Anemia de la ERC: desde TFG <45–60 (G3 en adelante); normocítica, normocrómica, arregenerativa (índice reticulocitario <2), por déficit de eritropoyetina y hepcidina alta.
- Pesquisa con hemograma y perfil de hierro periódico desde la etapa 3; Hb <8 g/dL obliga a buscar otra causa (sangrado, ferropenia, déficit de B12/folato).
- Primero hierro: reponer (EV u oral) hasta IST >20% y ferritina >100 ng/mL (>200 en hemodiálisis); dar EPO sin hierro produce resistencia.
- Luego EPO o darbepoetina con meta Hb 10–11,5 g/dL (techo 12); nunca >13 g/dL por más ACV, infarto y trombosis de la fístula. Efecto adverso frecuente: HTA.
- En ERC terminal la EPO y el hierro EV están cubiertos por el GES; si Hb >11,5–12, bajar EPO 25–50%.
- Seguimiento: derivar a nefrología para indicación y titulación de EPO.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 58 años con ERC en hemodiálisis crónica. Hemoglobina 8,8 g/dL, VCM normal. Cinética de hierro: saturación de transferrina 14 % y ferritina 65 ng/mL. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada para su anemia?**

A Hierro endovenoso hasta IST > 20 % y ferritina > 200 ng/mL

B Eritropoyetina en dosis plenas como monoterapia

C Transfusión inmediata de 2 unidades de glóbulos rojos

D Mielograma para descartar aplasia pura de serie roja

E Ácido fólico en dosis altas como único tratamiento

Respuesta A. Anemia de la ERC con ferropenia concomitante (IST < 20 %, ferritina < 200 en hemodiálisis). Dar EPO sin hierro es ineficaz (resistencia a EPO): primero se repone hierro endovenoso hasta las metas, y luego se inicia o titula la EPO con meta de Hb 10–11,5 g/dL.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 64 años con nefropatía diabética en hemodiálisis trisemanal por fístula braquiocefálica, en tratamiento con eritropoyetina. En su control mensual: Hb 8,7 g/dL, VCM 88 fL, ferritina 110 ng/mL, saturación de transferrina 14 %. Asintomática en reposo, PA 135/80 mmHg. La enfermera propone subir la eritropoyetina de 4.000 a 8.000 UI por sesión. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Aumentar la eritropoyetina a 8.000 UI por sesión

B Indicar hierro sacarato EV 100 mg en cada sesión de hemodiálisis

C Transfundir 2 unidades de glóbulos rojos

D Suspender la eritropoyetina por riesgo trombótico

E Indicar sulfato ferroso oral y controlar en 3 meses

Respuesta B. Ferritina < 200 ng/mL e IST < 20 %: ferropenia funcional. Subir la EPO sin hierro no eleva la Hb (resistencia) y aumenta costo y toxicidad. En hemodiálisis se repone hierro EV (sacarato 100 mg por sesión) hasta repletar. No hay indicación de transfusión ni de suspender la EPO con Hb 8,7.

▶ VER CLASE 1.09.1.005 Bacteriuria asintomática

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.4 · Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Bacteriuria asintomática: urocultivo ≥100.000 UFC/mL de un germen (2 muestras en la mujer) sin síntomas urinarios ni fiebre.
- No se trata en mujeres no embarazadas, diabéticas, adultos mayores ni portadores de sonda permanente: no reduce infecciones sintomáticas y genera resistencia.
- Sí se trata en la embarazada (30–40% progresa a pielonefritis): cefadroxilo por 7 días (nitrofurantoína como alternativa, evitar a las 36–40 semanas), con urocultivo de control 7–14 días después.
- También se trata antes de procedimientos urológicos con sangrado de mucosa (p. ej. resección transuretral).
- No pedir urocultivo de tamizaje fuera del embarazo; tampoco requiere estudio de imágenes.
- Seguimiento completo: en la embarazada urocultivo de control; tras pielonefritis o ≥2 ITU, profilaxis nocturna hasta el parto.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 72 años, diabética, sin síntomas urinarios ni fiebre, se realiza un urocultivo de rutina que muestra Escherichia coli con más de 100.000 UFC/mL en 2 muestras. No está embarazada ni tiene procedimientos urológicos programados. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Nitrofurantoína por 7 días

B No tratar la bacteriuria

C Ciprofloxacino por 14 días

D Profilaxis antibiótica permanente

E Ecografía renal y cistoscopía

Respuesta B. La bacteriuria asintomática en adultas mayores y diabéticas no se trata: no reduce las infecciones sintomáticas ni las complicaciones y favorece resistencia y efectos adversos. Solo se trata en embarazadas y antes de procedimientos urológicos con sangrado de mucosa, como la resección transuretral. Tampoco requiere estudio de imágenes.

▶ VER CLASE 1.09.1.006 Glomerulopatía lúpica

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 4.5 · Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica
Reumatología 9.9 · Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar nefritis lúpica en todo LES con proteinuria ≥0,5 g/24 h (o IPC ≥0,5), sedimento activo (≥5 hematíes dismórficos/campo o cilindros hemáticos) o caída inexplicada de la TFG.
- Marcadores de actividad: anti-dsDNA en títulos altos y C3/C4 bajos por consumo; la clínica no predice la lesión, por eso la biopsia renal es obligatoria.
- Clases ISN/RPS: I–II mesangiales, III focal (<50%) y IV difusa (≥50%, la más frecuente y grave, asas de alambre), V membranosa (nefrótico puro), VI esclerosante.
- Clases III–IV: hospitalizar, biopsia urgente e inducción con pulsos de metilprednisolona 0,5–1 g/día × 3 días + micofenolato o ciclofosfamida; mantención con MMF o azatioprina por 3–5 años.
- Medidas iniciales del médico general: hidroxicloroquina en todos, IECA/ARA-II para la proteinuria y la PA, cotrimoxazol profiláctico con inmunosupresión intensa.
- Seguimiento: derivar a nefrología o reumatología.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 113

Una paciente de 26 años, consulta por malestar general, asociada a cefalea y orinas oscuras. Refiere fotosensibilidad. Al examen físico tiene FC: 66x'. PA: 160/106 mmHg, úlceras orales y edema de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran sedimento de orina con eritrocitos abundantes, con 17% de dismorfia, proteinuria 500 mg/L. Su creatinina plasmática resulta 1,4 mg/dl y la fracción del complemento C3 está disminuida. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Nefropatía lúpica
B Nefropatía por IgA
C Vasculitis ANCA positivo
D Glomerulonefritis postestreptocócica
E Glomerulopatía por cambios mínimos

Respuesta A. Mujer joven con fotosensibilidad y úlceras orales (clínica de LES) que suma compromiso renal (hipertensión, hematuria, proteinuria, alza de creatinina) y C3 bajo: nefropatía lúpica. La IgA y las vasculitis ANCA cursan con complemento normal; la postestreptocócica requiere una infección previa; los cambios mínimos no dan hematuria ni C3 bajo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2017 · PREGUNTA 18

Mujer de 22 años con diagnóstico de LES consulta por astenia y edema facial matinal. En sus exámenes destaca creatinina de 1.4 mg/dL, proteinuria en orina de 24 horas de 2.2 gramos y sedimento urinario con 25 glóbulos rojos por campo con acantocitos y abundantes cilindros hemáticos. El C3 es de 45 mg/dL. ¿Cuál es el procedimiento mandatorio de elección para definir la conducta terapéutica e inmunosupresora?

A Tomografía computarizada contrastada de abdomen y pelvis
B Biopsia renal percutánea con microscopía óptica e inmunofluorescencia
C Cistoscopía diagnóstica con toma de muestra de mucosa vesical
D Iniciar antibióticos empíricos por sospecha de pielonefritis
E Urocultivo cuantitativo y diferir nuevas decisiones por 3 meses

Respuesta B. En un paciente con LES que debuta con proteinuria significativa (≥ 0.5 g/24h), sedimento urinario activo (hematuria glomerular con cilindros hemáticos) y deterioro de función renal, la realización de una biopsia renal percutánea es el examen de elección mandatario. Permite identificar la clase histopatológica de nefritis lúpica (según clasificación ISN/RPS) y los índices de actividad y cronicidad, de los cuales depende la agresividad del esquema inmunosupresor.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2019 · PREGUNTA 49

La biopsia renal de una paciente con LES informa una Nefritis Lúpica Clase IV (Proliferativa Difusa) con semilunas celulares en 30% de los glomérulos y necrosis fibrinoide activa. ¿Cuál es el esquema farmacológico de inducción de primera línea indicado para rescatar la función renal?

A Pulsos de Metilprednisolona endovenosa seguidos de Prednisona oral más Micofenolato Mofetilo
B Monoterapia con Hidroxicloroquina 200 mg al día sin corticoides
C Prednisona oral 10 mg al día más calcio y vitamina D
D Metotrexato 15 mg por semana más ácido fólico
E Infliximab endovenoso más AINEs a dosis plenas

Respuesta A. El tratamiento de inducción de primera línea para la Nefritis Lúpica Clase IV (proliferativa difusa, la forma más destructiva) consiste en la combinación sinérgica de corticoides a dosis altas (iniciando con pulsos de Metilprednisolona endovenosa de 500-1000 mg/día por 3 días consecutivos seguidos de prednisona oral) asociado a un inmunosupresor mayor potente como Micofenolato Mofetilo (2-3 g/día) o Ciclofosfamida EV.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2021 · PREGUNTA 05

¿Cuál de las siguientes clases histológicas de nefritis lúpica según la clasificación ISN/RPS cursa típicamente con síndrome nefrótico florido PURO, con engrosamiento difuso de la membrana basal sin proliferación endocapilar marcada y con menor consumo de complemento?

A Clase I (Mesangial mínima)
B Clase II (Proliferativa mesangial)
C Clase IV (Proliferativa difusa)
D Clase V (Membranosa)
E Clase VI (Esclerosante avanzada)

Respuesta D. La Nefritis Lúpica Clase V (Membranosa) se caracteriza por depósitos inmunes predominantemente subepiteliales que causan engrosamiento uniforme de la pared capilar. Clínicamente se manifiesta como un síndrome nefrótico puro con proteinuria en rango masivo, hipoalbuminemia y dislipidemia, habitualmente sin hematuria proliferativa y con complemento normal o mínimamente disminuido.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2023 · PREGUNTA 12

Una paciente de 27 años con nefritis lúpica Clase IV tratada exitosamente con micofenolato mofetilo y corticoides alcanza la remisión completa tras 6 meses de tratamiento. Desea conocer el pronóstico y la duración de la terapia de mantenimiento. ¿Cuál es la indicación correcta?

A Suspender toda la medicación inmunosupresora de inmediato por haber alcanzado la remisión

B Mantener la terapia inmunosupresora de mantención (micofenolato o azatioprina) por un mínimo de 3 a 5 años

C Continuar con pulsos mensuales de ciclofosfamida durante toda la vida

D Cambiar a prednisona 60 mg al día de forma permanente sin otros fármacos

E Suspender corticoides y realizar nueva biopsia renal mensual

Respuesta B. En la nefritis lúpica proliferativa que alcanza la remisión clínica completa tras los 6 meses de inducción, la terapia de mantenimiento (con Micofenolato Mofetilo a dosis de 1 a 2 g/día o Azatioprina) debe prolongarse por un mínimo estricto de 3 a 5 años antes de plantear un retiro gradual muy lento. Suspender precozmente la medicación condiciona una tasa de recaída renal superior al 50%.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 24 años con antecedente de LES diagnosticado hace 1 año en tratamiento irregular con hidroxicloroquina. Consulta por edema progresivo de extremidades inferiores hasta rodillas, orinas espumosas y cefalea. Al examen físico destaca PA 160/100 mmHg, edema pretibial +++ con fóvea, y eritema malar tenue. Exámenes: creatinina 1.9 mg/dL (basal 0.8 mg/dL hace 4 meses), nitrógeno ureico 38 mg/dL, albúmina sérica 2.4 g/dL. El examen de orina muestra proteinuria de 3.8 g/24 horas y sedimento con 30 a 40 glóbulos rojos dismórficos por campo y cilindros hemáticos. El complemento C3 está en 42 mg/dL y el Anti-dsDNA fuertemente positivo. **¿Cuál es el procedimiento diagnóstico mandatorio de elección y qué esquema farmacológico de inducción inicial debe indicarse de inmediato?**

A Biopsia renal percutánea urgente y hospitalización para pulsos de Metilprednisolona EV más Micofenolato Mofetilo

B Iniciar diálisis peritoneal de urgencia sin realizar biopsia renal

C Aumentar la dosis de hidroxicloroquina y citar a control ambulatorio en 3 meses

D Indicar ciprofloxacino oral por sospecha de infección urinaria complicada

E Tomografía computarizada con contraste endovenoso y furosemida oral exclusiva

Respuesta A. La paciente presenta un síndrome nefrítico-nefrótico severo con deterioro agudo de función renal e hipertensión arterial, altamente sugerente de Nefritis Lúpica proliferativa difusa activa (Clase IV). El procedimiento mandatario para clasificar histológicamente el daño renal es la biopsia renal percutánea perentoria. El tratamiento de inducción urgente de primera línea consiste en hospitalización, pulsos de Metilprednisolona endovenosa (500 a 1.000 mg/día por 3 días) seguidos de prednisona...

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 26 años con LES diagnosticado hace un año, en tratamiento irregular con hidroxicloroquina. Consulta por astenia, cefalea y orinas oscuras espumosas. Eritema malar, úlceras orales, PA 160/105 mmHg, edema bimaleolar. Creatinina 1,6 mg/dL (basal 0,7), sedimento con 80 % de hematíes dismórficos y cilindros hemáticos, proteinuria 2,4 g/24 h. C3 y C4 muy bajos, anti-dsDNA fuertemente positivo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Aumentar la hidroxicloroquina y controlar en un mes

B Enalapril y repetir la proteinuria en 6 meses

C Hospitalizar, biopsia renal urgente e inducción con pulsos de metilprednisolona + MMF o ciclofosfamida

D Prednisona oral en dosis bajas y alta

E Iniciar hemodiálisis crónica

Respuesta C. Brote lúpico con síndrome nefrítico activo (HTA, alza de creatinina, hematuria dismórfica, cilindros, proteinuria) y consumo de C3 y C4 con anti-dsDNA alto: orienta a nefropatía lúpica proliferativa (clase III o IV). Conducta: hospitalizar, biopsia renal urgente para clasificar e iniciar inducción con pulsos de metilprednisolona más micofenolato o ciclofosfamida.

▶ VER CLASE **1.09.1.007** **Hipernatremia, poliuria** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 7.24 · Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)
Nefrología 2.3 · Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipernatremia (Na >145) = déficit de agua libre: pensar en quien no accede al agua (postrado, intubado, lactante) o en poliuria hipotónica (diabetes insípida).
- Poliuria >3 L/día con Osm urinaria <300: prueba con desmopresina; si la Osm urinaria sube >50% es DI central (TEC, cirugía selar), si no cambia es nefrogénica (litio, hipercalcemia, hipokalemia).
- Con hipernatremia establecida no hacer prueba de privación de agua: ir directo a la desmopresina.
- Si hay shock: primero suero fisiológico 0,9%. Luego déficit de agua libre = ACT × (Na/140 − 1), con agua enteral o SG 5% en 48–72 h; bajar máximo 10–12 mEq/L en 24 h (riesgo de edema cerebral).
- DI central: desmopresina; DI por litio: suspender si es posible + hidroclorotiazida + amilorida.
- Seguimiento: derivar a endocrinología o nefrología para estudio de la causa.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 125

Paciente usuaria de lamotrigina, ácido valproico y litio, presenta diuresis de 12.600 mL/día, deshidratación e hipernatremia. **¿Cuál es la causa más probable?**

A Ácido valproico
B Carbonato de litio (diabetes insípida nefrogénica)
C Lamotrigina
D Polidipsia psicogénica inducida por antipsicóticos
E Hiperglicemia osmótica

Respuesta B. El carbonato de litio es la causa farmacológica número uno de diabetes insípida nefrogénica: el túbulo colector no responde a la ADH.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 94

Un paciente de 25 años, con antecedente de trastorno bipolar de difícil manejo, en tratamiento con lamotrigina, litio, diazepam, sertralina y clorpromazina, presenta un cuadro de poliuria de cerca de 12 litros diarios, asociado a alta ingesta de aguda. Se solicitan exámenes, que muestran creatinina plasmática: 0,7 mg/dl, BUN: 12 mg/dl, sodio: 154 mEq/L, potasio: 4,5 mEq/L, glicemia de ayunas: 80 mg/dl y hemograma normal. ¿Cuál de las siguientes opciones explica sus alteraciones?

A Polidipsia psicógena
B Consumo de lamotrigina
C Consumo de litio
D Consumo de clorpromazina
E Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (opción E).

▶ VER CLASE 1.09.1.008 Hipertensión arterial esencial

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 5.3 · Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico: PA ≥140/90 confirmada con perfil de presión arterial o MAPA (≥130/80 promedio de 24 h); descarta bata blanca y detecta HTA enmascarada. GES para HTA primaria en ≥15 años.
- Evaluación inicial: creatinina con TFG, potasio, glicemia, perfil lipídico, orina completa con RAC, ECG y fondo de ojo si es severa; buscar claves de HTA secundaria.
- Estilo de vida: sal <5 g/día, bajar de peso, dieta DASH, ejercicio aeróbico, moderar alcohol y dejar el tabaco.
- Fármacos de primera línea: IECA (enalapril) o ARA-II (losartán), calcioantagonista (amlodipino) o tiazida; con PA ≥160/100 iniciar de inmediato, idealmente en combinación. Betabloqueador no es primera línea sin indicación específica.
- Metas: <140/90 en general y <130/80 en diabéticos, ERC o alto riesgo cardiovascular; nunca combinar IECA + ARA-II.
- Seguimiento completo en APS (Programa de Salud Cardiovascular): controles hasta lograr meta y luego periódicos con TFG, K y RAC; HTA resistente (3 fármacos con diurético) obliga a estudiar causa secundaria.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 50 años, sin comorbilidades y no fumador, presenta en el perfil de presión arterial promedios de 164/102 mmHg. Examen físico, creatinina, potasio, orina completa y ECG normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solo cambios de estilo de vida por 6 meses y reevaluar
B Ecografía doppler de arterias renales antes de tratar
C Atenolol como primera línea
D Cambios de estilo de vida e inicio inmediato de un antihipertensivo, como losartán o amlodipino
E Repetir el perfil de presión arterial en 1 año

Respuesta D. Con PA de 160/100 o más (etapa 2) se inicia tratamiento farmacológico de inmediato junto con cambios de estilo de vida, usando IECA o ARA II, calcioantagonista o tiazida, idealmente en combinación si está muy sobre la meta. Los betabloqueadores no son primera línea sin una indicación específica, y sin claves de HTA secundaria no corresponde doppler renal.

▶ VER CLASE 1.09.1.009 Hipertensión arterial secundaria

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 7.14 · Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria
Nefrología 5.3 · Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar HTA secundaria en: inicio <30 o >55–60 años, HTA resistente (3 fármacos a dosis plenas, uno diurético), HTA severa de inicio brusco o hipokalemia espontánea.
- Hiperaldosteronismo primario (la causa endocrina más frecuente): HTA + hipokalemia, alcalosis y K urinario alto; tamizaje con relación aldosterona/renina (>20–30 con aldosterona >15), con K corregido y sin espironolactona.

- Renovascular: soplo abdominal en flanco, creatinina que sube >30% con IECA, edema pulmonar flash; primer examen eco Doppler de arterias renales (arteriografía es el estándar de oro y permite tratar).
- Displasia fibromuscular (mujer joven, collar de perlas): angioplastía con balón sin stent. Ateroesclerosis (adulto mayor): tratamiento médico intensivo; stent solo si falla.
- Otras causas: ERC parenquimatosa, feocromocitoma (crisis paroxísticas, metanefrinas), Cushing, hipotiroidismo, apnea del sueño, fármacos (AINE, corticoides, anticonceptivos).
- Manejo inicial: controlar la PA (en hiperaldosteronismo, espironolactona) y derivar a nefrología o endocrinología para confirmar y tratar la causa.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 1

Un paciente de 18 años consulta por cefalea de algunas semanas de evolución, que ha ido en aumento, hasta alcanzar gran intensidad. En su examen físico destaca presión arterial 170/100 mmHg, FC: 72x' y presencia de un soplo abdominal, en el flanco derecho. **El diagnóstico más probable es:**

A Disección aórtica
B Aneurisma aórtico abdominal
C Hipertensión esencial
D Hipertensión renovascular
E Accidente vascular encefálico

Respuesta D. HTA severa en un joven con soplo abdominal en el flanco: HTA renovascular clásica, a esta edad por displasia fibromuscular. El soplo es el flujo turbulento en la estenosis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 24

Un paciente de 65 años, con antecedente de hipertensión arterial, diagnosticada hace un año en tratamiento con atenolol 50 mg cada 12 horas y enalapril 20 mg cada 12 horas, refiere múltiples tomas de presión arterial con valores sobre 160/100 mmHg. Al examen físico tiene FC: 60x', PA: 158/100 mmHg, sin alteraciones en el examen segmentario. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 1,2 mg/dl, sodio: 143 mEq/L, potasio: 3,4 mEq/L, hemograma normal y TSH: 3,2 UI/L. **¿Con qué examen se debe proseguir su estudio?**

A Cortisol basal y post dexametasona
B Monitoreo de presión arterial de 24 horas
C Calcemia y niveles de paratohormona
D Metanefrinas y normetanefrinas en orina
E Ecografía Doppler de arterias renales

Respuesta E. HTA de inicio después de los 60 años, de difícil control con dos fármacos a dosis plenas y potasio en el límite inferior: sospecha de estenosis ateroesclerótica de la arteria renal. El examen no invasivo de primera línea es el Doppler de arterias renales.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 83

Paciente con HTA de difícil control, creatinina levemente elevada e hiperkalemia. **¿Cuál es el estudio a solicitar?**

A Ecografía Doppler de arterias renales
B Renograma isotópico con captopril
C Arteriografía renal selectiva
D AngioTAC renal
E Biopsia renal

Respuesta A. HTA de difícil control con deterioro de la función renal: sospecha de HTA renovascular. El primer estudio es el Doppler de arterias renales: no invasivo y sin contraste. AngioTAC y arteriografía vienen después, si se planifica intervenir.

▶ VER CLASE 1.09.1.010 Hiponatremia crónica asintomática

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 2.1 · Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica
Nefrología 2.2 · SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Primero confirmar hipotonía: Osm plasmática (2 × Na + glicemia/18) <275. Osm normal = pseudohiponatremia (triglicéridos, mieloma); alta = hiperglicemia (corregir +1,6–2 por cada 100 mg/dL).
- Clasificar por volemia y sodio urinario: hipovolémica (Na urinario <20 extrarrenal; >20 tiazidas, Addison), euvolémica (SIADH, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, polidipsia) o hipervolémica (IC, cirrosis, nefrótico).
- SIADH: euvolemia, Osm urinaria >100 y Na urinario >40, con tiroides, suprarrenal y riñón normales y sin diuréticos. Causas: ISRS, carbamazepina, cáncer pulmonar microcítico, patología del SNC o pulmonar.
- Tratamiento según volemia: hipovolémica con suero fisiológico 0,9%; SIADH con restricción hídrica 800–1.000 mL/día + NaCl oral y suspender el fármaco; hipervolémica con restricción + furosemida.
- Corregir como máximo 8–10 mEq/L en 24 h (6–8 en alcohólicos, desnutridos, cirróticos o hipokalémicos) para evitar desmielinización osmótica; sobrecorrección: SG 5% + desmopresina.
- Seguimiento: derivar para estudio etiológico (endocrinología o nefrología), sobre todo si no hay causa evidente o se sospecha neoplasia.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 49

Una paciente de 60 años, con antecedente de hipotiroidismo, hipertensión y depresión, en tratamiento con levotiroxina, enalapril y citalopram se realiza exámenes de control, entre los que destacan sodio plasmático de 127 mEq/L, potasio plasmático de 4,1 mEq/L, creatinina plasmática de 0,9 mg/dl y sodio urinario de 60 mEq/L. **¿Cuál es la causa más probable de su hiponatremia?**

A Uso del enalapril
B Reacción secundaria al citalopram
C Síndrome paraneoplásico
D Insuficiencia suprarrenal
E Hipotiroidismo descompensado

Respuesta B. Probable SIADH (hiponatremia con sodio urinario alto) inducido por citalopram, un ISRS.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 52 años, 5 días después del clipaje de un aneurisma por hemorragia subaracnoidea. FC 110 lpm, PA 90/60 mmHg (previa 135/85), PVC 2 cmH2O, diuresis 4.500 mL en 24 h, balance −2.800 mL. Na 126 mEq/L (basal 138), BUN 28 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL, Na urinario 88 mEq/L, Osm urinaria 450 mOsm/kg. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Restricción hídrica a 800 mL/día
B Suero fisiológico 0,9% intravenoso
C Furosemida intravenosa más NaCl oral
D Desmopresina subcutánea
E Suero glucosado al 5%

Respuesta B. Hiponatremia hipotónica con natriuresis alta en patología intracraneana, pero con hipovolemia evidente (hipotensión, taquicardia, PVC baja, balance negativo, BUN/Cr > 20): síndrome perdedor de sal cerebral. Se repone volumen y sodio con SF 0,9%. La restricción hídrica, correcta en el SIADH, aquí precipita shock y vasoespasmo.

▶ VER CLASE 1.09.1.011 Infección urinaria baja (cistitis)

DX ESPECÍFICO · TX COMPLETO · SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.4 · Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Cistitis: disuria, polaquiuria, urgencia y dolor suprapúbico, sin fiebre ni dolor lumbar (la cistitis no da fiebre). E. coli en 75–85%.
- En mujer joven no embarazada con síntomas típicos el diagnóstico es clínico: no requiere urocultivo. Nitritos negativos no descartan ITU.
- Tratamiento empírico: nitrofurantoína 100 mg c/12 h por 5 días; alternativas fosfomicina 3 g dosis única o cefalosporina oral (cefadroxilo). Reservar quinolonas.
- Pedir urocultivo en embarazo, hombre, recurrencia, falla de tratamiento o ITU complicada; embarazada: cefadroxilo 7 días y urocultivo de control.
- Recurrente (≥3/año): orinar después del coito, buena hidratación, no retener orina; si persiste, profilaxis poscoital (nitrofurantoína o cotrimoxazol en dosis única).
- Seguimiento completo en APS; no necesita control con urocultivo si hay respuesta clínica (salvo embarazo).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 26 años, sana y no embarazada, consulta por disuria, polaquiuria y urgencia miccional de 1 día. Está afebril, sin dolor lumbar ni flujo vaginal. Tira reactiva de orina: leucocitos y nitritos positivos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Nitrofurantoína 100 mg cada 12 horas por 5 días, sin urocultivo
B Urocultivo y esperar el resultado para tratar
C Ceftriaxona intramuscular por 3 días
D Ecografía renal y vesical
E Ciprofloxacino por 14 días

Respuesta A. Es una cistitis aguda no complicada: en una mujer joven con síntomas típicos no se requiere urocultivo y se trata empíricamente con nitrofurantoína por 5 días (alternativas: fosfomicina en dosis única o cefalosporina oral), considerando la resistencia local de E. coli. Las quinolonas se reservan, y 14 días o la vía parenteral corresponden a pielonefritis.

▶ VER CLASE 1.09.1.012 Insuficiencia renal crónica

DX SOSPECHA · TX INICIAL · SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.1 · Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- ERC: TFGe <60 mL/min/1,73 m² (CKD-EPI) o marcador de daño renal (RAC ≥30 mg/g, IPC ≥0,2, sedimento o imagen alterada) por >3 meses. Primeras causas: diabetes e HTA.
- Etapificar con KDIGO: G1 ≥90, G2 60–89, G3a 45–59, G3b 30–44, G4 15–29, G5 <15; y albuminuria A1 <30, A2 30–300, A3 >300 mg/g.
- Nefroprotección: IECA o ARA-II si hay albuminuria (aunque sea normotenso) + iSGLT2 (dapagliflozina); aceptar alza de creatinina <30%; pausar si sube >30% o K >5,5. PA <130/80.

- Ajustar fármacos: metformina máximo 1.000 mg/día con TFG 30–44 y suspender <30; evitar AINE; sodio <2 g/día; estatina; vacunar contra hepatitis B y neumococo.
- Desde G3 pesquisar anemia, CKD-MBD (Ca, P, PTH, 25-OH-vitamina D) y acidosis.
- Seguimiento en APS con TFG y RAC cada 6–12 meses; TFG <30 es GES N° 1: notificar y nefrólogo en ≤30 días, fístula AV ≥6 meses antes de dializar.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 62 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial consulta a control en Cesfam. Trae exámenes que muestran creatinina de 2,1 mg/dL, con TFG estimada de 24 mL/min/1,73 m² (confirmada con examen similar hace 4 meses). No presenta síntomas urémicos. **De acuerdo a la normativa GES en Chile, ¿cuál es la conducta que debe adoptar el médico tratante?**

A Notificar caso GES N° 1 de ERC etapa 4 y generar interconsulta prioritaria a Nefrología para ingreso en menos de 30 días

B Instalar catéter venoso central transitorio para hemodiálisis en el servicio de urgencias

C Citar a nuevo control en atención primaria en un año para reevaluar función renal

D Iniciar diálisis peritoneal ambulatoria de forma inmediata en el consultorio

E Indicar restricción hídrica estricta de 500 mL/día y suspender todo tratamiento oral

Respuesta A. TFG de 24 mL/min confirmada por más de 3 meses: ERC etapa 4. El GES N° 1 cubre las etapas 4 y 5: se notifica y se deriva al nefrólogo, que debe atender en un plazo máximo de 30 días para optimizar el manejo, vacunar contra hepatitis B y planificar la fístula arteriovenosa.

▶ VER CLASE 1.09.1.013 Nefritis intersticial no infecciosa (aguda o crónica)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 1.2 · Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)

QUÉ HAY QUE SABER

- Nefritis intersticial aguda: causada por fármacos en >75% (betalactámicos, AINE, IBP, sulfas); hipersensibilidad mediada por células.
- Sospechar ante alza de creatinina días a semanas tras iniciar un fármaco, con fiebre, exantema y eosinofilia (la tríada completa aparece solo en 10–15%).
- Sedimento: piuria estéril (urocultivo negativo), cilindros leucocitarios y microhematuria; eosinofiluria sugerente pero no específica.
- Primera medida: suspender el fármaco culpable (medida curativa). Si no mejora en 5–7 días o creatinina >3–4 mg/dL: prednisona 1 mg/kg/día por 2–4 semanas.
- Nefritis intersticial crónica: AINE crónicos, litio, nefropatía por analgésicos o reflujo; evoluciona a ERC con poliuria y acidosis tubular.
- Seguimiento: derivar a nefrología, sobre todo si no revierte o se plantean corticoides.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 133

Un paciente de 27 años presenta una lesión en la pierna derecha, consistente en una placa eritematosa solevantada. Se inicia cloxacilina endovenosa. Al quinto día, la lesión cutánea ha mejorado, sin embargo, evoluciona con malestar general, fiebre y aparición de un exantema macular eritematoso generalizado. Se solicitan exámenes que muestran sedimento de orina con hematuria microscópica, hemograma con leucocitosis y 20% de eosinófilos, BUN 30 mg/dL y creatinina 2,0 mg/dL. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Glomerulonefritis aguda postestreptocócica

B Púrpura trombocitopénico trombótico

C Vasculitis sistémica primaria

D Insuficiencia renal aguda prerrenal

E Nefritis intersticial

Respuesta E. Fiebre y exantema generalizado a los 5 días de iniciar cloxacilina, con eosinofilia del 20% y deterioro de la función renal: nefritis tubulointersticial aguda secundaria a un Síndrome DRESS por betalactámico. La glomerulonefritis postestreptocócica y la vasculitis no explican la eosinofilia tan marcada asociada al fármaco.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 167

Paciente de 36 años con fiebre y la presencia de una lesión en miembro inferior, en forma de una placa de eritematosa, con bordes definidos de aproximadamente 15 x 8 cm, que responde bien al tratamiento con cloxacilina. Al quinto día comienza con náuseas, vómitos, diuresis adecuada, con leucocitosis de 15.000 por mm3, con 10% de eosinófilos, 40% de neutrófilos y 48% de linfocitos, uremia en 50 mg/dl, creatinina en 3 mg/dl, hematuria microscópica, leucocituria, y proteinuria de 0,8 g/día. **Identificar el posible diagnóstico:**

A Glomerulonefritis post estreptocócica

B Vasculitis de vasos pequeños

C Injuria renal pre renal

D Endocarditis infecciosa

E Nefritis intersticial

Respuesta E. Mismo escenario sin exantema: betalactámico, eosinofilia, leucocituria y falla renal no oligúrica. Sigue siendo una nefritis intersticial por fármacos; la tríada completa no es necesaria.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 54 años, hospitalizado hace 10 días por osteomielitis en tratamiento con cefazolina IV. Presenta febrícula de 37,8 °C y exantema eritematoso pruriginoso en el tronco. Creatinina sube de 1,0 a 2,6 mg/dL. Leucocitos 9.800 con 9 % de eosinófilos. Sedimento: 30–40 leucocitos por campo, cilindros leucocitarios; urocultivo negativo. **¿Cuál es la primera conducta?**

A Suspender la cefazolina y rotar a otra familia antibiótica

B Iniciar prednisona 1 mg/kg/día manteniendo la cefazolina

C Agregar ciprofloxacino por infección urinaria

D Hidratación agresiva con suero fisiológico

E Hemodiálisis de urgencia

Respuesta A. Betalactámico + febrícula + exantema + eosinofilia + piuria estéril con cilindros leucocitarios: nefritis intersticial aguda inmunoalérgica. La primera medida es suspender el fármaco. Los corticoides se reservan si no mejora en 5–7 días; el urocultivo negativo descarta la infección urinaria.

▶ VER CLASE 1.09.1.014 Nefropatía diabética

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.1 · Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector

QUÉ HAY QUE SABER

- Nefropatía diabética: primera causa de ERC terminal y de hemodiálisis; el primer signo es la albuminuria por hiperfiltración glomerular.
- Tamizaje con RAC en primera orina matinal: DM2 desde el diagnóstico y DM1 a los 5 años del debut; luego anual, junto con creatinina y TFGe.
- Confirmar con 2 de 3 RAC alteradas en 3–6 meses, descartando falsos positivos (ITU, fiebre, ejercicio intenso, hiperglicemia marcada, IC descompensada).
- Albuminuria A2 (30–299 mg/g) o A3 (≥300): IECA o ARA-II aunque sea normotenso (nunca ambos) + iSGLT2 si TFG >20–25; A3: dosis máxima y derivar.
- Metas: PA <130/80, HbA1c individualizada, estatina; metformina se ajusta con TFG <45 y se suspende <30.
- Seguimiento completo en el Programa de Salud Cardiovascular (RAC y TFG anual); derivar a nefrología si A3, caída rápida de TFG o TFG <30 (GES N° 1).

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 76

Un paciente de 46 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, acude a control, refiere estar asintomático. Al examen físico se encuentra presión arterial de 138/83, sin otros hallazgos. Sus exámenes de control muestran hemoglobina glicosilada en 6.9%, indice proteinuria creatininuria de 0.3, creatinina 0.8 mg/mL. **La conducta más adecuada en este caso es:**

A Aumentar dosis de metformina

B Iniciar hidroclorotiazida

C Iniciar enalapril

D Suspender metformina e indicar insulina

E Mantener tratamiento actual y reforzar medidas como dieta y ejercicio

Respuesta C. PA sobre la meta del diabético (< 130/80) y proteinuria positiva: se inicia un IECA. La HbA1c de 6,9 % está en meta, así que no hay que tocar la metformina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 114

Un paciente de 62 años, diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina 850 mg/8h, hidroclorotiazina 50 mg/día y atenolol 50 mg/día, acude a control. Su presión arterial es 146/100 mmHg, Su examen físico segmentario no aporta mayor información. Trae algunos exámenes, entre los que destacan clearence de creatinina de 48 mililitros por minuto y proteinuria de 500 mg/litro. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Agregar amlodipino

B Agregar doxazosina

C Agregar enalapril

D Mantener las indicaciones

E Reemplazar la hidroclorotiazida por furosemida

Respuesta C. Diabético hipertenso, fuera de meta y con proteinuria: le falta el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Se agrega un IECA, que además protege el riñón. Ni la tiazida ni el atenolol lo reemplazan.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 144

Un paciente diabético de larga data en tratamiento con empagliflozina 10 mg al día, metformina 1.000 mg cada 8 horas y atorvastatina 20 mg al día, presenta presiones arteriales de 140/90 mmHg y 158/87 mmHg en dos controles diferentes. El resto de su examen físico es normal y trae exámenes, entre los que destaca hemoglobina glicosilada de 6.9%. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar terapia depletiva de potasio

B Iniciar tratamiento antihipertensivo

C Solicitar un monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)

D Iniciar terapia antiagregante plaquetaria

E Iniciar insulina

Respuesta B. En el diabético la meta es < 130/80 mmHg; con dos controles claramente sobre ese valor se inicia tratamiento antihipertensivo (IECA o ARA-II de primera línea). La HbA1c está en meta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 84

Diabético con nefropatía, HTA reciente, creatinina 1,5 mg/dL y proteinuria. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A Amlodipino
B Atenolol
C Hidroclorotiazida
D Enalapril
E Losartán

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Enalapril (opción D). Enalapril.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 62

Un paciente diabético de larga data, en tratamiento con insulina, presenta presión arterial de 148/102. Además su índice proteinuria/creatininuria resulta 0,3. ¿Qué fármaco es más adecuado para el manejo de este paciente?

A Amlodipino
B Enalapril
C Carvedilol
D Hidroclorotiazida
E Diltiazem

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Enalapril (opción B). Tanto por la HTA, como por la proteinuria se debe iniciar enalapril en el diabético.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 54

Un paciente de 50 años, con antecedente de diabetes mellitus, en tratamiento con metformina 1g cada 12 horas y sitagliptina 50 mg cada 12 horas, presenta presiones arteriales de 148/92 mmHg, que se repiten en varios días, con valores entre 140/90 y 150/100. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran creatinina plasmática: 1,5 mg/dl, índice proteinuria/creatininuria: 2,2, electrolitos plasmáticos muestran Na+: 138 mEq/L, K+: 4,2 mEq/L, Cl-: 103 mEq/L; HbA1c: 6,6%. ¿Cuál es el fármaco de elección para el manejo de este paciente?

A Doxasocina
B Enalapril
C Hidroclorotiazida
D Diltiazem
E Amlodipino

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Hidroclorotiazida (opción C).

▶ VER CLASE 1.09.1.015 Osteodistrofia en insuficiencia renal crónica

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.2 · Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis

QUÉ HAY QUE SABER

- CKD-MBD: la ERC retiene fósforo, sube FGF-23 y deja de activar la vitamina D (falta 1-alfa-hidroxilasa); baja el calcio y aparece hiperparatiroidismo secundario.
- Sospechar desde G3: dolor óseo, fracturas, prurito, calcificaciones vasculares; laboratorio con Ca, P, PTH intacta y 25-OH-vitamina D.
- PTH alta con Ca y P normales en G3–G4: primer examen 25-OH-vitamina D; si <30 ng/mL dar colecalciferol antes de calcitriol, paricalcitol o cinacalcet.
- Fósforo alto: dieta (800–1.000 mg/día, menos lácteos, bebidas cola y procesados) y quelantes con las comidas; carbonato o acetato de calcio si hay hipocalcemia, sevelamer si hipercalcemia o calcificaciones.
- Metas: P 2,5–4,5 mg/dL en G3–G4, calcio 8,5–10,2 mg/dL, PTH 2–9 veces el límite normal en diálisis.
- Seguimiento: derivar a nefrología (en ERC terminal vitamina D y quelantes están en el GES).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 140

Un paciente de 64 años, con antecedente de insuficiencia renal crónica, con clearence de 40 ml/min se realiza exámenes de control que muestran fósforo: 4,0 mg/dl, calcio: 8,5, PTH: 120 pg/ml (VN: menor a 55) y TSH: 4,0 UI/L. **¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?**

A Niveles plasmáticos de 25-OH-vitamina D
B Niveles de T4 libre
C Calciuria de 24 horas
D Magnesemia
E Bicarbonato plasmático

Respuesta A. PTH alta con calcio normal-bajo: hiperparatiroidismo secundario. El examen para evaluar los depósitos de vitamina D es la 25(OH)D; su déficit empeora el cuadro y debe descartarse como causa.

▶ VER CLASE 1.09.1.016 Pielonefritis aguda no complicada

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.4 · Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Pielonefritis: fiebre >38,5 °C con calofríos, dolor lumbar y puñopercusión (Giordano) positiva, con o sin síntomas urinarios bajos (pueden faltar en el anciano).
- Sedimento con piuria y bacterias (cilindros leucocitarios indican origen renal); urocultivo con antibiograma siempre, antes del antibiótico, sin retrasar el tratamiento.
- Ambulatoria si no hay criterios de hospitalización (embarazo, intolerancia oral, sepsis, obstrucción, falla renal, inmunosupresión).
- Tratamiento: ciprofloxacino 500 mg c/12 h por 7 días si la resistencia local es baja, o cefalosporina oral (cefadroxilo, cefixima) por 10–14 días. Nitrofurantoína y fosfomicina no sirven (no alcanzan el parénquima).
- Control a las 48–72 h: si persiste febril con germen sensible, imagen (TAC con contraste o ecografía) para descartar absceso u obstrucción.
- Seguimiento completo: ajustar según antibiograma; no requiere urocultivo de control si hay buena respuesta (salvo embarazo).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 27 años, sana, no embarazada, con 2 días de disuria, fiebre de 38,7 °C y dolor lumbar derecho. Puño percusión derecha positiva. Tolera la vía oral, PA 115/70 mmHg, FC 98 lpm. Orina con leucocituria y nitritos positivos. Resistencia local de E. coli a quinolonas menor de 10 %. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Nitrofurantoína 100 mg cada 6 horas por 5 días

B Urocultivo y ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas por 7 días, ambulatorio

C Hospitalizar y ceftriaxona más ampicilina endovenosa

D Fosfomicina 3 g en dosis única

E TAC de abdomen y pelvis antes de iniciar antibiótico

Respuesta B. Pielonefritis no complicada en mujer sana que tolera la vía oral: manejo ambulatorio, urocultivo previo y ciprofloxacino 7 días si la resistencia local es baja (alternativa: cefalosporina oral). Nitrofurantoína y fosfomicina no alcanzan niveles en el parénquima renal y sirven solo para cistitis.

▶ VER CLASE 1.09.1.017 Progresión de la IRC

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.1 · Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Progresión acelerada de la ERC: caída de TFG >5 mL/min/1,73 m² en un año o cambio de categoría G; la albuminuria A3 (RAC >300 mg/g) predice progresión.
- Buscar causas reversibles: depleción de volumen, AINE y nefrotóxicos, contraste yodado, obstrucción urinaria, HTA o glicemia descontrolada, infección.
- Optimizar: IECA o ARA-II a dosis máxima tolerada + iSGLT2, PA <130/80, control glicémico, sal <2 g/día, estatina, dejar el tabaco.
- Proteínas 0,6–0,8 g/kg/día en G3–G5 sin diálisis; ajustar dosis de fármacos según TFG.
- Criterios de derivación a nefrología: progresión acelerada, RAC >300 mg/g, TFG <30, hematuria glomerular o HTA resistente.
- Seguimiento: derivar; TFG <30 es GES N° 1 (nefrólogo en ≤30 días) para preparar terapia de reemplazo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 61 años, hipertenso, con ERC en control en CESFAM. Hace 1 año TFGe 58 mL/min/1,73 m²; hoy 45 mL/min/1,73 m², confirmada en 2 mediciones. RAC 420 mg/g. PA 136/84 mmHg con losartán 50 mg/día. K 4,6 mEq/L. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener el control anual en atención primaria

B Iniciar preparación para diálisis con fístula arteriovenosa

C Suspender el losartán por la caída de la TFG

D Derivar a nefrología por progresión acelerada y albuminuria severa

E Solicitar biopsia renal en atención primaria

Respuesta D. Una caída de la TFG mayor de 5 mL/min/1,73 m² en un año define progresión acelerada, y una RAC sobre 300 mg/g es albuminuria severa: ambos son criterios de derivación a nefrología. Mientras, se optimiza el bloqueo del sistema renina-angiotensina y la PA bajo 130/80 mmHg.

▶ VER CLASE 1.09.1.018 Proteinuria

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 4.1 · Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas

QUÉ HAY QUE SABER

- Proteinuria normal <150 mg/24 h. Se cuantifica con IPC en muestra aislada (≥0,2 es patológico) o RAC (≥30 mg/g); la orina de 24 h queda para casos puntuales.
- En jóvenes sanos suele ser transitoria (ejercicio, fiebre) u ortostática: repetir en primera orina de la mañana en reposo; si es negativa, no requiere estudio.
- Proteinuria persistente: estudiar con creatinina/TFG, sedimento, glicemia, PA y ecografía renal; con hematuria dismórfica pensar en glomerulonefritis.
- Rango nefrótico >3,5 g/24 h (IPC >3–3,5) con albúmina <3 g/dL y edema = síndrome nefrótico: en el adulto requiere biopsia.
- Tratamiento inicial: IECA o ARA-II (antiproteinúricos aunque sea normotenso) + iSGLT2, meta proteinuria <0,5–1 g/día y PA <130/80.

- Seguimiento completo en APS de la proteinuria leve (diabéticos, hipertensos); derivar a nefrología si >1 g/día, nefrótico o sedimento activo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 135

Un deportista de 25 años corre un triatlón. Luego de la competencia, en el control de dopaje, se realiza un examen de orina que muestra proteinuria ++, sin presencia de drogas. **¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de su proteinuria?**

A Proteinuria funcional
B Rabdomiólisis
C Deshidratación
D Acidosis metabólica
E Glomerulopatía membranosa

Respuesta A. El ejercicio intenso produce una proteinuria funcional transitoria por cambios hemodinámicos glomerulares, que desaparece en 24 a 48 horas. Se confirma repitiendo el examen en reposo; si persiste, se estudia. No hay clínica de rabdomiólisis (mialgias, orina oscura, CK elevada), y una glomerulopatía membranosa daría proteinuria persistente y edema.

▶ VER CLASE 1.09.1.019 Riñón poliquístico

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.14 · Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante

QUÉ HAY QUE SABER

- Poliquistosis renal autosómica dominante (PKD1 85%, más severa; PKD2 15%): antecedente familiar de diálisis, masas renales bilaterales palpables, HTA precoz, hematuria y dolor lumbar sordo.
- Diagnóstico por ecografía: múltiples quistes bilaterales con nefromegalia; quistes hepáticos en >70%. Diferenciar del quiste simple (anecogénico, pared fina, refuerzo posterior: alta sin control).
- Complicación más temida: aneurisma de Berry del polígono de Willis (8–10%, 20% con historia familiar); cefalea súbita = TAC de cerebro urgente por HSA.
- Otras complicaciones: litiasis, infección de quistes, hemorragia quística, diverticulosis y prolapso mitral; progresa a ERC terminal.
- Manejo inicial: control estricto de PA con IECA o ARA-II (meta <130/80), hidratación abundante; angio-RM si cefalea atípica o historia familiar de aneurisma.
- Seguimiento: derivar a nefrología; consejo genético y tamizaje de familiares.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 38 años, su padre murió a los 52 años en hemodiálisis. Dolor sordo bilateral en los flancos. PA 160/100 mmHg. Se palpan masas renales lobuladas bilaterales. Ecografía: múltiples quistes en ambos riñones de 17 cm y quistes hepáticos. Creatinina 1,6 mg/dL. **¿Cuál es el diagnóstico y el pilar del manejo?**

A Quistes simples; alta sin control
B Poliquistosis renal; control estricto de la presión con IECA o ARA-II
C Carcinoma renal bilateral; nefrectomía
D Hidronefrosis bilateral; derivación urinaria
E Pielonefritis crónica; antibióticos

Respuesta B. Historia familiar, nefromegalia bilateral palpable, hipertensión, quistes hepáticos y creatinina elevada son una poliquistosis renal autosómica dominante. El pilar es controlar la presión con bloqueadores del sistema renina-angiotensina (meta bajo 130/80).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 35 años con poliquistosis renal autosómica dominante e hipertensión en tratamiento consulta por cefalea súbita e hiperaguda, "la peor de su vida", con vómitos explosivos y rigidez de nuca. **¿Cuál es la complicación vascular subyacente más probable?**

A Trombosis de la vena renal bilateral
B Rotura de aneurisma sacular del polígono de Willis con hemorragia subaracnoidea
C Encefalopatía hipertensiva con microhemorragias pontinas
D Rotura de quiste renal infectado con shock séptico
E Disección de aorta torácica tipo A

Respuesta B. Entre 8 y 10% de los pacientes con PQRAD tiene aneurismas saculares del polígono de Willis (20% si hay historia familiar). Su rotura produce hemorragia subaracnoidea: cefalea en trueno, signos meníngeos y TAC de cerebro sin contraste urgente.

▶ VER CLASE 1.09.1.020 Edema generalizado (anasarca)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 2.4 · Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica

QUÉ HAY QUE SABER

- Edema generalizado: separar las 4 grandes causas con examen y laboratorio: cardíaca (yugulares, crépitos), hepática (ascitis, estigmas), renal (proteinuria) y desnutrición/hipoalbuminemia.
- Primer examen útil: orina completa con proteinuria; proteinuria >3,5 g/24 h con albúmina <3 g/dL = síndrome nefrótico (edema matinal palpebral y vespertino en piernas).

- Completar con creatinina, albúmina, perfil hepático, BNP/ecocardiograma según sospecha y TSH.
- Tratamiento inicial: restricción de sodio (<2 g/día) y diurético de asa (furosemida 40–80 mg/día, meta bajar 0,5–1 kg/día); en cirrosis, espironolactona + furosemida 100:40.
- La tiazida pierde eficacia con TFG <30: usar furosemida. Vigilar sodio, potasio y función renal.
- Seguimiento: derivar según la causa (nefrología, cardiología o gastroenterología).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 56

Un paciente de 75 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, sin tratamiento, consulta por edema de las extremidades inferiores y malestar. Al examen físico tiene PA: 150/100 mmHg, FC: 70x', edema marcado en ambas extremidades inferiores, con signo de la fóvea, hígado palpable, examen cardíaco normal y murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos basales. En sus exámenes destaca creatinina: 2,2 mg/dl, Na+: 136 mEq/l, K+: 5,3 mEq/l y Cl-: 95 mEq/l. **¿Qué diurético es de elección para el manejo del edema en este paciente?**

A Clortalidona
B Hidroclorotiazida
C Furosemida
D Indapamida
E Espironolactona

Respuesta C. Edema con falla renal (creatinina 2,2) y signos de congestión: el diurético de elección es el de asa. Las tiazidas (clortalidona, hidroclorotiazida, indapamida) pierden eficacia con la filtración reducida, y la espironolactona arriesga más hiperkalemia (K 5,3).

▶ VER CLASE **1.09.1.021** **Síndrome nefrítico** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 4.3 · Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)
Urología 13.15 · Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome nefrítico: hematuria glomerular (orina color té o coca-cola), edema, HTA y oliguria, con proteinuria subnefrótica (<1–2 g/día).
- Sedimento: dismorfia >70–80%, acantocitos >5% y cilindros hemáticos (patognomónicos de origen glomerular).
- Glomerulonefritis postestreptocócica: latencia 1–2 semanas tras faringitis o 3–6 semanas tras impétigo, C3 bajo con C4 normal, ASO o anti-DNAsa B positivos; típica de 5–15 años.
- IgA (Berger): hematuria sinfaringítica (24–48 h) con C3 y C4 normales. C3 bajo por más de 8–12 semanas: biopsia (lupus o membranoproliferativa).
- Tratamiento inicial de la postestreptocócica: restricción de sodio y líquidos + furosemida; sin corticoides. Emergencia hipertensiva o edema pulmonar: furosemida IV y antihipertensivo IV.
- Seguimiento: derivar a nefrología; si la creatinina sube en semanas, sospechar GNRP (urgencia).

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 64

Un paciente de 80 años consulta por equimosis periorbitaria, sin antecedente traumático, asociado a astenia y edema de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes, entre los que destacan creatinina: 2,6 mg/dl, proteinuria de 24 horas: 8,4 gramos/día, albuminemia: 1,4 g/dl. Su hemograma es normal y su VHS: 96 mmHg. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Nefrosis lipoidea
B Nefropatía diabética
C Amiloidosis primaria
D Enfermedad de Berger
E Arteritis de la temporal

Respuesta C. Síndrome nefrótico en un adulto mayor de 65 años con equimosis periorbitaria espontánea y VHS muy elevada: amiloidosis primaria (AL), ligada a gammapatía monoclonal o mieloma.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 48

Un paciente de 22 años, con antecedente de una amigdalitis bacteriana, hace 2 semanas, con tratamiento antibiótico incompleto, presenta un cuadro de cefalea y orinas espumosas, asociado a edema de extremidades inferiores. Al examen físico, tiene PA: 180/110 mmHg, FC: 62 lpm. Se solicitan exámenes, que muestran creatinina: 2,0 mg/dl, BUN: 46 mg/dl, sedimento de orina con abundantes glóbulos rojos, con 80% de dismorfia, ANA (-) y proteinuria de 900 mg/24 horas; C3 y C4 bajos. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A Diuréticos
B Antiinflamatorios
C Antibióticos
D Inmunosupresores
E Corticoides

Respuesta A. Glomerulonefritis postestreptocócica clásica (latencia de 2 semanas, nefrítico, hipocomplementemia). Se trata con soporte: diuréticos para el edema y la hipertensión. No se usan corticoides ni inmunosupresores.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 65

Un paciente de 32 años presenta un cuadro de dos días de odinofagia, fiebre y mialgias, a lo que se agrega hematuria. En sus exámenes destaca sedimento de orina con incontables glóbulos rojos, con 9% de dismorfia, creatinina plasmática de 0,7 mg/dl, BUN: 13 mg/dl, C3 y C4 en niveles normales y proteinuria de 500 mg/día. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Nefropatía mesangiocapilar
B Lupus
C Glomerulonefritis postestreptocócica
D Nefropatía por IgA
E Vasculitis de vaso pequeño

Respuesta D. Hematuria a los 2 días de una faringitis (sinfaringítica) con C3 y C4 normales: nefropatía por IgA. La postestreptocócica, la lúpica y la mesangiocapilar (membranoproliferativa) bajan el C3.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 148

Paciente de 20 años de edad, sin antecedentes, con coriza, tos y odinofagia desde hace dos días manejadas con ibuprofeno, paracetamol y clorfenamina, consulta por aparición de hematuria el día de hoy, asociado a los síntomas antes descritos. Al examen físico presenta presión arterial de 120/70, frecuencia cardiaca normal, resto sin hallazgos patológicos. Se solicita examen de orina que muestra: glóbulos rojos 40-50 por campo con 20% de dismorfismo y cilindros hemáticos. El diagnóstico más probable es: **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Glomerulonefritis post estreptocócica
B Glomerulonefritis lúpica
C Glomerulonefritis mesangial
D Glomerulonefritis por IgA
E Glomerulonefritis por drogas

Respuesta D. Enfermedad de Berger con glomerulonefritis aguda, en relación a una infección respiratoria, sin otros síntomas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 22 años con 3 días de cefalea, hinchazón facial y orinas color café. Hace 12 días tuvo una faringoamigdalitis purulenta tratada 3 días con amoxicilina. PA 175/105 mmHg, edema periorbitario y de tobillos. Creatinina 1,9 mg/dL. Sedimento: incontables glóbulos rojos con 85 % de dismorfia y cilindros hemáticos; proteinuria 800 mg/24 h. C3 28 mg/dL (VN 80–160), C4 normal. **¿Cuál es el tratamiento inicial de elección?**

A Prednisona 1 mg/kg/día
B Restricción de sodio y furosemida
C Completar 10 días de amoxicilina como tratamiento del daño renal
D Pulsos de ciclofosfamida
E Biopsia renal antes de cualquier medida

Respuesta B. Latencia de 12 días tras faringitis, síndrome nefrítico y C3 bajo con C4 normal: glomerulonefritis postestreptocócica. Es autolimitada; se trata la sobrecarga de volumen con restricción de sodio y furosemida. No se usan corticoides y el antibiótico no cambia el daño glomerular ya instalado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 83

Una paciente de 21 años, consulta por cuadro de algunos días de evolución de aste- nia, compromiso del estado general y disnea progresiva que actualmente es de mínimos esfuerzos, además ha presentado hematuria. Al examen físico su frecuencia cardiaca es 75 por minuto, con presión arterial 180/110 mmHg. Se aprecia edema facial y de extre- midades inferiores, con signo de la fóvea. Su examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en tres tiempos con presencia de R3 y se auscultan crépitos pulmonares bilate- rales, mayores en ambas bases. Se solicitan exámenes que muestran hematuria dismór-

A Prednisona vía oral
B Furosemida endovenosa
C Bisoprolol vía oral
D Captopril vía oral
E Amoxicilina vía oral

Respuesta B. B? Tiene un glomerulonefritis aguda postestreptocócica, con un síndrome nefrítico y una insuficiencia cardiaca, por la crisis hipertensiva. Dada la sobrecarga de volumen, la furosemida ev parece ser el tratamiento más razonable, pero el captopril también po- dría ser de utilidad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 50

Un paciente de 30 años, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de rinorrea, tos y disfonía, a lo que se agregó hematuria. Al examen físico presenta frecuencia car- diaca de 80 latidos por minuto, con presión arterial 150/100 mmHg, edema blando de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes entre los que destaca sedimento de ori- na con 15 leucocitos por campo más incontables eritrocitos con 9% de dismorfia, protei- nuria de 24 horas de 2 gramos y creatinina de 1,7mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Glomerulonefritis post estreptocócica
B Nefropatía por depósitos de IgA
C Litiasis renal
D Pielonefritis aguda
E Lupus eritematoso sistémico

Respuesta B. Diagnóstico: Nefropatía por depósitos de IgA (opción B). Es un Berger clásico. La glomerulonefritis se diagnostica con sedimento urinario que muestra hematuria dismórfica (acantocitos) o cilindros hemáticos/eritrocitarios.

▶ VER CLASE 1.09.1.022

Síndrome nefrótico

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 4.1 · Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas
Nefrología 4.2 · Glomerulopatías Primarias del Adulto: Cambios Mínimos, FSGS y Membranosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome nefrótico: proteinuria >3,5 g/24 h (o IPC >3–3,5) y albúmina <3 g/dL, con edema blando, dislipidemia (colesterol >350–400) y lipiduria (cruz de Malta); sin hematuria significativa ni HTA.
- Adulto: biopsia renal obligatoria (excepto diabetes de larga data con retinopatía concordante o amiloidosis demostrada). Niño 1–10 años: 90% cambios mínimos, prednisona sin biopsia.
- Causas del adulto: membranosa (>50 años, anti-PLA2R, buscar cáncer sólido y VHB), GEFS (adulto joven, VIH, obesidad), cambios mínimos (Hodgkin, AINE), amiloidosis (>65 años, mieloma).
- Complicaciones: trombosis (vena renal, TEP) por pérdida de antitrombina III; infecciones por neumococo por pérdida de IgG.
- Manejo inicial: sodio <2 g/día, furosemida, IECA o ARA-II a dosis máxima + iSGLT2, estatina; HBPM profiláctica si albúmina <2–2,5 g/dL en membranosa; vacuna antineumocócica.
- Seguimiento: derivar a nefrología para biopsia e inmunosupresión.

PREGUNTAS · 10

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 154

Un paciente de 33 años, hospitalizado por una endocarditis subaguda por Streptococcus viridans, en tratamiento con penicilina y gentamicina por vía endovenosa, presenta un cuadro de hematuria de algunos días de evolución. Se solicita sedimento de orina que muestra 50 glóbulos rojos por campo con 95% de dismorfia y presencia de cilindros hemáticos, creatinina de 2,4 mg/dL, ANA (-), fracción C3 del complemento de 53 mg/dL (valor normal: 75-135 mg/dL). **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Embolias renales a repetición
B Nefritis intersticial secundaria al uso de penicilina
C Daño tubular agudo secundario al uso de gentamicina
D Glomerulonefritis por depósito de complejos inmunes
E Síndrome hemolítico urémico

Respuesta D. Hematuria dismórfica con cilindros hemáticos y C3 bajo: el daño es glomerular, por complejos inmunes asociados a la endocarditis. Ni la nefritis intersticial (piuria estéril, cilindros leucocitarios) ni la necrosis por gentamicina (cilindros granulosos) dan cilindros hemáticos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 10

Hombre de 35 años sin antecedentes previos consulta por edema facial al despertar, orina espumosa y aumento de peso de 5 kg en 2 semanas. Proteinuria 24h: 8 g. Albúmina 2.0 g/dL. Sin hematuria. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Síndrome nefrótico puro
B Síndrome nefrítico agudo
C Glomerulonefritis membranoproliferativa
D Nefropatía IgA
E Pielonefritis crónica

Respuesta A. Proteinuria masiva (> 3,5 g/24 h) + hipoalbuminemia + edema, sin hematuria: síndrome nefrótico puro. Las glomerulonefritis cursan con hematuria dismórfica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 59

Una paciente de 27 años, diabética tipo 1, con mal control metabólico, consulta por edema de las extremidades inferiores y orinas espumosas. Al examen físico se constata edema palpebral y facial, edema blando de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca hemoglobina glicosilada de 8,2%, ANA negativos, sedimento de orina con abundantes cuerpos ovales grasos, 2-3 glóbulos rojos por campo y 2-4 glóbulos blancos por campo, creatinina: 1,2 mg/dl y proteinuria cuantitativa de 9 g en 24 horas. **¿Cuál es la conducta de elección para proseguir el manejo de esta paciente?**

A Electroforesis de proteínas en sangre

B Biopsia renal

C Inmunofijación de proteínas en orina

D Prednisona oral

E Solicitar ANCA, C3 y C4

Respuesta B. Síndrome nefrótico en una adulta joven: la biopsia es obligatoria. La diabetes no basta para exceptuarla (no es de larga data con retinopatía concordante). Los ANCA son marcadores de vasculitis, que dan cuadros nefríticos, no nefróticos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 3

Paciente de 65 años, diabético en tratamiento con esquema intensificado de insulina, actualmente hospitalizado por cuadro de edema generalizado en estudio, presenta dolor torácico de inicio súbito, asociado a diaforesis. Al examen físico destaca saturación de 89% con FiO2 ambiental, murmullo pulmonar con crepitaciones difusas bilaterales. En sus exámenes de laboratorio destaca proteinuria de 24 horas de 5gramos, albúmina de 2g/dL y perfil lipídico con triglicéridos de 450 mg/dL. **La causa más probable de su dolor torácico es:**

A Neumonía aguda

B Tromboemolismo pulmonar

C Infarto agudo al miocardio

D Pericarditis aguda

E Disección aórtica

Respuesta B. Síndrome nefrótico (proteinuria 5 g, albúmina 2 g/dL) con dolor torácico súbito y desaturación: tromboembolismo pulmonar, por la pérdida urinaria de antitrombina III.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 66

Un paciente de 62 años presenta un cuadro de varios días de evolución, de orinas espumosas, asociado a edema marcado de extremidades inferiores. Su sedimento de orina muestra 2-4 hematíes por campo, 5-10 leucocitos por campo, creatininemia de 1,2 mg/dl y proteinuria de 24 horas de 7 gramos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Nefropatía por IgA

B Enfermedad renal lúpica

C Glomerulonefritis postestreptocócica

D Glomerulonefritis mesangiocapilar

E Nefropatía membranosa

Respuesta E. Síndrome nefrótico puro (7 g/24 h, sedimento sin hematuria dismórfica) en un adulto de 62 años: nefropatía membranosa. Las demás son glomerulonefritis con hematuria dismórfica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 26

Un paciente de 62 años presenta edema de extremidades inferiores, asociada a malestar general y aumento de volumen facial. Al examen físico tiene FC: 60x', PA: 120/80 mmHg, edema de párpados y de extremidades inferiores, con signo de la fóvea. Se solicitan exámenes, que muestran glicemia: 147 mg/dl, hemoglobina glicosilada: 6,8%, sedimento de orina con 5 eritrocitos por campo y 2 a 3 leucocitos por campo, proteinuria de 500 mg/dl, colesterol total: 411 mg/dl, albúmina plasmática: 2,1 g/dl y creatinina: 0,9 mg/dl. **El diagnóstico más probable es:**

A Nefropatía diabética

B Nefropatía membranosa

C Nefropatía lúpica

D Nefropatía a cambios mínimos

E Nefropatía por IgA

Respuesta B. Síndrome nefrótico clásico (edema, proteinuria masiva, albúmina 2,1 g/dL, colesterol 411 mg/dL) en un adulto de 62 años: membranosa. La diabetes es reciente (HbA1c 6,8 %), sin la larga data que exige una nefropatía diabética.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 64 años, fumador, con 3 semanas de edema de extremidades inferiores hasta los muslos, orinas espumosas y alza de 6 kg de peso. PA 130/80 mmHg. Albúmina 2,1 g/dL, colesterol total 420 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL. Proteinuria de 24 horas: 8,6 g. Sedimento: 2 eritrocitos por campo y abundantes cuerpos ovales grasos con cruces de Malta. No es diabético. **¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?**

A Iniciar prednisona 1 mg/kg/día de forma empírica

B Realizar biopsia renal percutánea

C Solicitar ANCA y anticuerpos anti-membrana basal

D Indicar losartán y controlar la proteinuria en 6 meses

E Solicitar cistoscopía

Respuesta B. Síndrome nefrótico puro en un adulto no diabético: la biopsia renal es obligatoria para definir la histología (lo más probable a esta edad es una membranosa) y guiar el tratamiento. Con albúmina de 2,1 g/dL además hay que evaluar anticoagulación profiláctica.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 62 años con semanas de orina espumosa y edema de extremidades inferiores. PA 125/80 mmHg, creatinina 1,1 mg/dL, albúmina 2,2 g/dL, proteinuria 7,5 g/24 h. Sedimento con 2 eritrocitos por campo, sin acantocitos. La biopsia renal muestra engrosamiento difuso de las paredes capilares con espículas subepiteliales en la tinción de plata e IgG granular en la inmunofluorescencia. **Además de solicitar anti-PLA2R, ¿cuál es la conducta prioritaria?**

A Iniciar prednisona 1 mg/kg/día como único tratamiento

B Buscar neoplasia sólida oculta: colonoscopía e imagen de tórax

C Solicitar serología de VIH como único estudio

D Repetir la biopsia con microscopía electrónica

E Iniciar hemodiálisis

Respuesta B. Spikes e IgG granular subepitelial: nefropatía membranosa. En un adulto mayor es obligatorio descartar una causa secundaria, sobre todo una neoplasia sólida oculta (colon, pulmón, mama). La prednisona sola sirve en cambios mínimos; el VIH se asocia a la GEFS.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 14

Una paciente de 34 años, diabética con control metabólico irregular, consulta por edema de las extremidades inferiores y orinas espumosas. Al examen físico se constata edema palpebral y facial, edema blando de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca hemoglobina glicosilada de 8,2% y proteinuria cuantitativa de 9 g en 24 horas. ¿Cuál es la conducta de elección para proseguir el manejo de esta paciente?

A Electroforesis de proteínas en sangre

B Biopsia renal

C Inmunofijación de proteínas en orina

D Prednisona oral

E ANCA, C3 y C4

Respuesta B. Pregunta muy difícil, pero tiene un claro síndrome nefrótico, que, por estar en contexto de una diabetes, se sospecha sea por nefropatía membranosa. Por ser una mujer joven, también podría ser un lupus, con nefropatía membranosa. De las opciones, solo la biopsia renal serviría para avanzar en el diagnóstico. Sí hay que solicitar ANA y complemento (no ANCA, ya que las vasculitis son nefríticas).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 121

Paciente 36 años, sin antecedentes de importancia, cursa con un cuadro de un mes de evolución de edema de EEII que posteriormente se agrega edema bipalpebral que aparece en las mañanas. Al examen físico, presenta FC: 96'x, TA: 130/70 mmHg, se constata edema de miembros inferiores, en ambos tobillos, que asciende hasta la pierna. Se solicitan exámenes de laboratorio, que muestran creatininemia 1,7 mg/dl, BUN 20 mg/dl, albúmina: 3,0 g/dl, examen de orina con densidad: 1020 g/L, glucosuria (-), nitritos (-), proteínas (++), eritrocitos: 2-3 x campo, leucocitos 3-5 x campo. El diagnóstico más probable es:

A Síndrome nefrítico

B Síndrome nefrótico

C Síndrome cardiorrenal

D Injuria renal aguda

E Hiperaldosteronismo primario

Respuesta B. Es un síndrome nefrótico clásico (proteinuria, edema, hipoalbuminemia). No hay hematuria ni HTA, así que no puede ser nefrítico.

▶ VER CLASE 1.09.1.023 **Síndrome urémico** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 1.3 · Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU)

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome urémico: falla renal avanzada (aguda o crónica) con toxinas que dañan otros órganos; la cifra de creatinina sola no indica diálisis.
- Encefalopatía urémica: letargia, desorientación, asterixis, mioclonías y luego convulsiones o coma. Pericarditis urémica: dolor pleuropericárdico y frote.
- Sangrado urémico por disfunción plaquetaria: desmopresina 0,3 mcg/kg revierte transitoriamente el defecto. Otros: náuseas, prurito, anorexia, desnutrición.
- Indicaciones de diálisis urgente (AEIOU): acidosis refractaria (pH <7,15 o HCO_3 <10), hiperkalemia >6,5 con ECG o refractaria, intoxicación dializable, sobrecarga de volumen refractaria y uremia sintomática.

- Pericarditis urémica: hemodiálisis urgente sin heparina (riesgo de taponamiento). Primera sesión corta y a flujo bajo para evitar desequilibrio dialítico; catéter en yugular interna derecha.
- Seguimiento: derivar a nefrología para terapia de reemplazo renal (GES N° 1).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 62 años con enfermedad renal crónica avanzada sin diálisis. Traído por 48 horas de desorientación y somnolencia progresiva. Estuporoso, con asterixis bilateral. Frote sistodiastólico en el borde esternal izquierdo. Creatinina 9,2 mg/dL, BUN 120 mg/dL, K 5,2 mEq/L, pH venoso 7,28, HCO_3 16 mEq/L. Sin congestión pulmonar. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Hemodiálisis de urgencia sin heparina sistémica

B Hemodiálisis de urgencia con heparina en dosis plenas

C Bicarbonato IV y control de gases en 6 horas

D Observar: el potasio y el pH no están en rango de diálisis

E Furosemida en altas dosis y restricción hídrica

Respuesta A. Encefalopatía urémica (asterixis) y pericarditis urémica (frote): criterio U, indicación absoluta de hemodiálisis urgente aunque el potasio y el pH no estén en rango crítico. La pericarditis obliga a evitar la heparinización plena por riesgo de hemopericardio y taponamiento.

▶ VER CLASE 1.09.1.024 Urolitiasis

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.1 · Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Urolitiasis: cálculos de oxalato de calcio en 75–80% (radiopacos); ácido úrico 5–10% (radiolúcidos, orina ácida, gota); estruvita coraliforme por Proteus; cistina rara.
- Sospechar ante cólico renal (dolor lumbar súbito irradiado a genitales, inquietud, vómitos, microhematuria) o hallazgo de cálculos en imagen.
- Examen de elección: pieloTAC sin contraste; ecografía en embarazadas y niños. La radiografía simple sirve para seguir cálculos radiopacos.
- Prevención para todos: agua >2,5 L/día (diuresis >2 L), dieta baja en sodio con calcio normal. Estudio metabólico en recurrentes, monorrenos, niños, bilaterales o cálculos no cálcicos.
- Según la causa: hipercalciuria con hidroclorotiazida; ácido úrico o hipocitraturia con citrato de potasio (± alopurinol); estruvita: antibióticos y remoción del cálculo.
- Seguimiento: derivar a urología si >10 mm, no expulsa en 4 semanas, recurrente o complicado.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 49

Un paciente ha presentado 5 episodios de litiasis ureteral en los últimos años. **¿Cuál es la alteración metabólica más probable en este paciente?**

A Hipercalciuria

B Hiperoxaluria

C Hiperuricosuria

D Hipocitraturia

E Cistinuria

Respuesta A. La mayoría de los cálculos urinarios son de oxalato de calcio, y la alteración metabólica más frecuente en litiásicos recurrentes es la hipercalciuria, idiopática en la mayoría de los casos, seguida de hipocitraturia e hiperoxaluria. La cistinuria es rara y genética. En la litiasis recurrente está indicado el estudio metabólico con orina de 24 horas.

▶ VER CLASE 1.09.1.025 Uropatía obstructiva

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.2 · Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Uropatía obstructiva: baja (HPB, estenosis uretral, vejiga neurógena, fármacos anticolinérgicos u opiáceos) o alta (cálculo, tumor, compresión extrínseca).
- Sospechar ante globo vesical, incontinencia por rebalse, oliguria o anuria, o alza de creatinina; ecografía renal y vesical muestra hidronefrosis y residuo.
- Primer paso ante injuria renal aguda: descartar obstrucción con ecografía y examen del globo vesical.
- Obstrucción baja: sonda Foley 16–18 Fr con descompresión continua; con trauma uretral o sonda imposible, cistostomía suprapúbica. Obstrucción alta: catéter doble J o nefrostomía percutánea (urología).
- Tras descomprimir >1.000 mL vigilar diuresis postobstructiva (poliuria, hipovolemia, hipokalemia) y electrolitos.
- Seguimiento: derivar a urología para tratar la causa; obstrucción infectada o monorreno es urgencia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 79 años con síntomas urinarios obstructivos de años presenta tenesmo vesical, goteo y dolor hipogástrico. Al examen se palpa globo vesical. Creatinina 3,8 mg/dL (basal 1,1). La ecografía muestra hidroureteronefrosis bilateral y vejiga distendida. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Instalación de sonda vesical Foley

B Nefrostomía percutánea bilateral

C Hemodiálisis de urgencia

D Iniciar tamsulosina y control en 1 semana

E Resección transuretral de próstata de urgencia

Respuesta A. Es una uropatía obstructiva baja con insuficiencia renal posrenal por hiperplasia prostática con retención crónica. Lo primero es descomprimir la vejiga con sonda Foley, lo que resuelve la hidronefrosis bilateral, vigilando la poliuria posobstructiva. La nefrostomía se usa en la obstrucción alta y la diálisis no corresponde si se corrige la causa.

Situaciones clínicas de urgencia

13 códigos

▶ VER CLASE 1.09.2.001

Cólico nefrítico, urolitiasis y complicaciones: obstrucción, sepsis, insuficiencia renal

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Urología 13.1 · Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Cólico renal: dolor lumbar súbito e intenso irradiado a flanco y genitales, inquietud sin posición antiálgica, vómitos, puñopercusión positiva y microhematuria.
- Analgesia antes de cualquier examen: AINE EV (ketorolaco 30 mg o ketoprofeno 100 mg); tramadol o morfina solo de rescate. Sin sueros rápidos ni diuréticos.
- Confirmar con pieloTAC sin contraste (ecografía en embarazo y niños); en adultos mayores descartar aneurisma aórtico roto.
- Según tamaño: <5 mm observar (expulsa 80–90%), 5–10 mm tamsulosina 0,4 mg/día por 28 días, >10 mm resolución urológica (LEOC o ureteroscopía).
- Banderas rojas que obligan a descomprimir de urgencia con catéter doble J o nefrostomía: fiebre o sepsis (pionefrosis), monorreno, anuria o falla renal, dolor refractario.
- Seguimiento por el médico general: control en 2–4 semanas con imagen, filtrar la orina, agua >2,5 L/día; si no expulsa o se dilata la vía, derivar a urología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 40 años consulta por dolor lumbar derecho cólico irradiado a la ingle, con náuseas. La TAC sin contraste muestra un cálculo de 6 mm en el uréter distal derecho con hidronefrosis leve. **¿Cuál de los siguientes hallazgos obliga a hospitalizar y resolver la obstrucción en forma urgente?**

A Hematuria microscópica

B Dolor que cede con ketorolaco

C Fiebre de 38,8 °C con escalofríos

D Cálculo menor de 10 mm

E Antecedente de un cólico renal previo

Respuesta C. Un cólico renal con fiebre sugiere uropatía obstructiva infectada, que puede evolucionar rápido a sepsis: requiere hospitalización, antibióticos y drenaje urgente de la vía urinaria con catéter doble J o nefrostomía. Otras indicaciones de hospitalizar son monorreno, falla renal, dolor refractario o vómitos incoercibles. La hematuria es esperable en el cólico.

▶ VER CLASE 1.09.2.002

Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Cardiología 5.2 · Crisis Hipertensivas: Urgencia vs Emergencia Hipertensiva
Oftalmología 15.13 · Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar

QUÉ HAY QUE SABER

- Crisis hipertensiva: PA ≥180/120. Urgencia = sin daño agudo de órgano blanco; emergencia = con daño agudo (encefalopatía, ACV, SCA, edema pulmonar, disección aórtica, falla renal aguda, preeclampsia severa, retinopatía con hemorragias/exudados o edema de papila).
- Evaluación: examen neurológico, fondo de ojo (Keith-Wagener-Barker: grado IV con edema de papila = HTA maligna), ECG, troponina, creatinina, orina completa.
- Urgencia hipertensiva: reposo y antihipertensivo oral (captopril, amlodipino, losartán), bajar en 24–48 h y control precoz. Nunca nifedipino sublingual.
- Emergencia: UCI con fármaco EV titulable (labetalol o nitroprusiato; nitroglicerina en SCA o edema pulmonar), bajar la PAM 20–25% en las primeras horas, nunca de golpe.
- Excepciones: disección aórtica (PAS <120 en 20 minutos); ACV isquémico (no bajar salvo >220/120, o >185/110 si va a trombólisis); preeclampsia severa (labetalol o nifedipino + sulfato de magnesio).
- Seguimiento completo: ajustar tratamiento oral, buscar causa secundaria y controlar en APS en días.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 63 años con hipertensión arterial crónica acude a control. En el fondo de ojo se observan arteriolas retinianas estrechadas de aspecto brillante y cobrizo, y a nivel de los cruces arteriovenosos se aprecia un afilamiento y ocultamiento del trayecto de las vénulas por debajo de las arteriolas (signo de Gunn positivo), sin hemorragias ni exudados. **¿A qué grado de la clasificación de Keith-Wagener-Barker corresponde este hallazgo?**

A Grado I

B Grado II

C Grado III

D Grado IV

E Retinopatía proliferativa grado B

Respuesta B. Cruces arteriovenosos patológicos (signo de Gunn o de Salus), junto con esclerosis arteriolar, sin hemorragias, exudados ni edema de papila, definen el grado II de Keith-Wagener-Barker. El grado I solo tiene estrechamiento arteriolar; el grado III añade hemorragias y exudados; el grado IV suma edema de papila.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 55 años, hipertensa crónica con mal control de su tratamiento oral, consulta por control habitual sin síntomas visuales. Presión arterial 190/115 mmHg. Al fondo de ojo se observan hemorragias retinianas en llama y exudados algodonosos en ambos ojos, sin cruces arteriovenosos patológicos adicionales relevantes y con bordes papilares nítidos, sin edema. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tranquilizarla y controlar en un año, ya que está asintomática

B Hospitalizar de inmediato en la unidad de cuidados intensivos e iniciar labetalol endovenoso

C Ajustar de forma rápida el tratamiento antihipertensivo y controlar estrechamente, sin necesidad de ingreso a UCI

D Indicar nifedipino sublingual para normalizar la presión arterial en minutos

E Solicitar únicamente una angiografía con fluoresceína antes de decidir cualquier conducta

Respuesta C. Hemorragias en llama y exudados algodonosos sin edema de papila corresponden a un grado III de Keith-Wagener-Barker: urgencia hipertensiva con isquemia retiniana aguda, que exige ajustar el tratamiento de forma rápida y controlar estrechamente, pero sin los criterios de emergencia maligna que exige el grado IV.

▶ VER CLASE 1.09.2.003 Edema generalizado grave (anasarca)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 4.1 · Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas

QUÉ HAY QUE SABER

- Anasarca: edema generalizado con compromiso de pared abdominal, escroto o genitales, ascitis y derrames; causas: síndrome nefrótico, IC, cirrosis, desnutrición grave.
- En el nefrótico la hipoalbuminemia (<2 g/dL) y la proteína tubular reducen la respuesta a diuréticos.
- Manejo inicial: restricción de sodio y diurético de asa en dosis altas (furosemida EV); asociar tiazida si hay resistencia; en refractarios albúmina EV + furosemida.
- No restringir líquidos en forma extrema ni usar albúmina sola; vigilar función renal, potasio y sobrecarga pulmonar.
- Nefrótico grave: IECA/ARA-II, estatina y evaluar anticoagulación si albúmina <2–2,5 g/dL (TVR, TEP); disnea súbita = descartar TEP.
- Seguimiento: derivar a nefrología (biopsia e inmunosupresión) o al especialista según la causa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 42 años con síndrome nefrótico por glomerulopatía membranosa presenta anasarca: edema de extremidades, pared abdominal y escroto, con ascitis. Proteinuria 9 g/24 h, albúmina 1,9 g/dL, creatinina 1,0 mg/dL, PA 140/88 mmHg. **¿Cuál es el manejo más adecuado del edema?**

A Albúmina endovenosa diaria como tratamiento único

B Restricción de sodio y diurético de asa (furosemida)

C Restricción estricta de líquidos a 500 mL/día

D Paracentesis evacuadora diaria

E Espironolactona como única medida

Respuesta B. El edema nefrótico se maneja con restricción de sodio y diuréticos de asa en dosis altas, porque la hipoalbuminemia y la proteína tubular reducen su efecto; puede asociarse tiazida y, en casos refractarios, albúmina con furosemida. Además se indica IECA o ARA II para reducir la proteinuria y se evalúa anticoagulación por la albúmina muy baja.

▶ VER CLASE 1.09.2.004 Enfermedad tubular aguda

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 1.1 · Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca

Nefrología 1.2 · Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)

QUÉ HAY QUE SABER

- Necrosis tubular aguda: 85% de las IRA intrínsecas hospitalarias; causas isquemia prolongada (shock), nefrotóxicos (aminoglucósidos, contraste, vancomicina, anfotericina) y pigmentos.
- Perfil: FeNa >2%, Na urinario >40, BUN/creatinina <15, isostenuria (Osm <350, densidad 1.010) y cilindros granulosos pardos con células tubulares.

- Rabdomiólisis: ejercicio extremo, calor o trauma, orina color té, tira con sangre positiva sin glóbulos rojos (mioglobina) y CPK >5.000–10.000; hidratación agresiva con cristaloides.
- Manejo: suspender nefrotóxicos, ajustar fármacos, balance neutro (500 mL + diuresis del día), vigilar AEIOU; furosemida para forzar diuresis es un error.
- Regenera en 1–3 semanas; en la fase poliúrica vigilar deshidratación e hipokalemia.
- Seguimiento: derivar a nefrología, sobre todo si hay criterio de diálisis.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 96

Un hombre de 32 años presenta dolor muscular y oliguria, 24 horas después de realizar ejercicio intenso, a lo que se agrega malestar general. En sus exámenes destaca creatininemia de 5 mg/dl, uremia de 9 mg/dl y potasemia de 5,4 mEq/L, con natremia: 140 UI/L. **¿Qué examen debe pedirse a continuación?**

A Creatininkinasa
B Proteinuria de 24 horas
C Hemograma
D Sedimento de orina
E Clearence de creatinina

Respuesta A. Mialgias y oliguria tras ejercicio intenso, con falla renal: sospecha de rabdomiólisis con necrosis tubular por mioglobina. El examen que confirma es la creatinquinasa (CPK).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 64 años, al tercer día de una colectomía, cursó con shock séptico por filtración anastomótica que requirió noradrenalina por 36 horas y recibió amikacina. Hoy diuresis de 300 mL en 24 horas. Creatinina 3,8 mg/dL (basal 1,0). Sodio urinario 58 mEq/L, FeNa 3,2 %. Sedimento: abundantes cilindros granulosos pardos y células epiteliales tubulares. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Insuficiencia renal aguda prerrenal
B Glomerulonefritis rápidamente progresiva
C Nefritis intersticial aguda por fármacos
D Necrosis tubular aguda isquémica y nefrotóxica
E Insuficiencia renal aguda obstructiva

Respuesta D. Shock prolongado más aminoglucósido, FeNa mayor de 2 %, sodio urinario alto y cilindros granulosos pardos (barro) son el perfil de la necrosis tubular aguda: el túbulo dañado ya no reabsorbe sodio. En lo prerrenal el sodio urinario es bajo y el sedimento es blando.

▶ VER CLASE 1.09.2.005 Hiperkalemia grave

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 3.1 · Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana

QUÉ HAY QUE SABER

- Hiperkalemia grave: K >6,5 mEq/L o con cambios ECG (T picuda, PR largo, P plana, QRS ancho, onda sinusoidal); puede dar tetraparesia flácida y bradicardia.
- Paso 1, membrana: gluconato de calcio 10% 10 mL IV en 2–5 minutos (repetir si persiste el ECG a los 5–10 min); actúa en 1–3 min, dura 30–60 min y no baja el potasio.
- Paso 2, redistribuir: insulina regular 10 UI IV + 50–100 mL de SG 30% (inicio 15–30 min) y salbutamol nebulizado 10–20 mg; bicarbonato solo si pH <7,1 o HCO_3 <12.
- Paso 3, eliminar: furosemida 40–80 mg IV si orina; quelantes intestinales (lentos); hemodiálisis de urgencia si anúrico, dializado que omitió sesión o refractaria.
- Monitor ECG continuo y vía venosa; en bradicardia el marcapasos no captura sin calcio previo. K alto con ECG normal y trombocitosis o hemólisis: repetir muestra (pseudohiperkalemia).
- Seguimiento: derivar a nefrología para manejar la causa (ERC, fármacos).

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 151

Un paciente de 27 años, con antecedente de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, no asiste a su sesión dialítica del día sábado, debido a que acude a una fiesta con abundante consumo de comida y bebidas. El día lunes amanece con marcado malestar general y dificultad para mover las extremidades, por lo que es llevado al servicio de urgencia. Al examen físico se constata tetraparesia y frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Síndrome de Guillain-Barré
B Hipokalemia
C Hiperkalemia
D Hipocalcemia
E Hiperfosfatemia

Respuesta C. Paciente en hemodiálisis que falta a su sesión y come en exceso: hiperkalemia, que da debilidad muscular y bradiarritmias. El primer examen es el ECG; el primer tratamiento, gluconato de calcio IV.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 107

Paciente con bradicardia de 30 lpm e hiperkalemia de 8,3 mEq/L. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Bicarbonato de sodio endovenoso
B Insulina + glucosa endovenosa
C Gluconato de calcio endovenoso
D Kayexalate oral
E Hemodiálisis de urgencia

Respuesta C. Hiperkalemia grave con repercusión cardíaca: lo primero es estabilizar la membrana miocárdica con gluconato de calcio IV. Después se desplaza el potasio (insulina + glucosa, salbutamol) y se elimina; la diálisis se reserva para lo refractario o el paciente anúrico.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 28 años en hemodiálisis trisemanal, omite su sesión del sábado tras una reunión con abundante asado y cítricos. El lunes llega con paresia flácida de las 4 extremidades, en sopor, FC 34 lpm, PA 75/40 mmHg. ECG: sin ondas P, ritmo idioventricular, QRS de 180 ms y T picudas. K 8,6 mEq/L, pH 7,24, HCO3 14 mEq/L. Ya recibió gluconato de calcio al 10% IV. **¿Cuál es la medida que elimina el potasio en forma definitiva en este paciente?**

A Furosemida 80 mg IV
B Salbutamol nebulizado 10 a 20 mg
C Hemodiálisis de urgencia
D Sulfonato de poliestireno sódico oral
E Bicarbonato de sodio IV

Respuesta C. Dializado que omitió su sesión, con hiperkalemia de 8,6 y toxicidad cardíaca: tras el calcio y en paralelo al shifting, la eliminación definitiva es la hemodiálisis de urgencia. La furosemida requiere diuresis; el salbutamol solo redistribuye; las resinas tardan horas; el bicarbonato no está indicado con pH 7,24 y HCO3 14, y es ineficaz en el anúrico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 104

Una paciente de 73 años, diabética e hipertensa, con insuficiencia renal crónica, en tratamiento con insulina NPH, losartán, amlodipino y atenolol, presenta malestar general, seguido de síncopes en varias oportunidades en día de hoy, por lo que es llevada a la urgencia. Al examen físico tiene FC: 30x', PA: 70/36 mmHg, sopor profundo, sudoración, ausencia de signos focales. Se solicitan exámenes de laboratorio entre los que destaca Na+: 130 mEq/L, K+: 8,2 mEq/L, Cl-: 98 mEq/L, pH: 7,29, HCO3-: 18 mEq/L, glicemia capilar: 180 mg/dl. El resto de la analítica está pendiente. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A Instalar marcapasos externo transitorio
B Administrar gluconato de calcio endovenoso
C Administrar atropina
D Hemodiálisis de urgencia
E Administrar suero fisiológico endovenosos

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Administrar suero fisiológico endovenosos (opción E).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 159

Paciente presenta bradicardia de hasta 35, Hipotensa, K 8, Cual es la primera medida a. Gluconato de Ca → Una paciente con bradicardia y potasio como 7-8 (creo que esta había salido antes en algun EUNACOM) b. Diálisis de urgencia

C MCP transitorio (POR QUE ESTA NO ES SI TIENE UN BLOQUEO AV SI EN EL MARCAPASO SE VA A MORIR, porque lo primero en toda hiperK y arritmia es estabilizar membrana con Gluconato Ca)
B Insuficiencia cardíaca
C Fibrilación auricular
D Infarto agudo al miocardio
E Tromboembolismo pulmonar

Respuesta A. La alternativa correcta es la A ().

▶ VER CLASE 1.09.2.006 **Hipokalemia** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 4.3 · Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato
Nefrología 3.2 · Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipokalemia: K <3,5 mEq/L; debilidad ascendente, calambres, hiporreflexia, íleo; si <2,0 rabdomiólisis y parálisis diafragmática.
- ECG: T aplanada, infradesnivel ST, onda U (V2–V4), QT aparente largo, ectopias y torsades; en usuarios de digoxina mantener K >4.
- Causas: tiazidas y diuréticos de asa (la más frecuente ambulatoria), diarrea, vómitos; K urinario >20 con HTA sin diurético: pensar en hiperaldosteronismo primario.
- Reposición oral si tolera y K >2,5–3,0 sin síntomas (KCl retard o gluconato de K). EV si K <2,5, cambios ECG o intolerancia oral.
- KCl periférico: máximo 40 mEq/L y 10–20 mEq/h, diluido en suero fisiológico (nunca glucosado), con bomba y monitor; central hasta 20–40 mEq/h en arritmia grave.

- Si no sube pese a aporte adecuado: medir y reponer magnesio (sulfato de magnesio IV). Seguimiento completo: suspender o cambiar la tiazida, controlar K y buscar la causa.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 18 años con DM1 llega a urgencia en cetoacidosis severa: glicemia 460 mg/dL, pH venoso 7,08. Ionograma: Na 134 mEq/L, Cl 96 mEq/L, K 2,9 mEq/L. Ya recibió el primer litro de suero fisiológico. El interno prepara un bolo de 10 UI de insulina cristalina EV y una bomba a 6 UI/h. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Aprobar el bolo y la bomba de insulina, y reponer potasio cuando la glicemia baje de 250 mg/dL

B Postergar la insulina e infundir KCl a 20–30 mEq/h hasta que el K supere 3,3 mEq/L

C Administrar bicarbonato de sodio y luego iniciar la insulina

D Iniciar la bomba de insulina sin bolo, con 20 mEq de KCl por litro de suero

E Cambiar a insulina NPH subcutánea para que el potasio baje más lento

Respuesta B. Con K menor de 3,3 mEq/L la insulina está contraindicada: mete el poco potasio extracelular a la célula y precipita hipokalemia severa, fibrilación ventricular y paro. Primero KCl a 20–30 mEq/h; la insulina parte cuando el K supera 3,3. El pH de 7,08 no indica bicarbonato.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 68 años, hipertensa, en tratamiento con hidroclorotiazida 50 mg/día, con 4 días de diarrea acuosa. Consulta por debilidad muscular marcada y palpitaciones. Está lúcida, PA 120/70 mmHg. K 2,3 mEq/L, Na 136 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL. ECG: ondas U prominentes, depresión del ST y extrasístoles ventriculares frecuentes. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Cloruro de potasio oral y control ambulatorio en 1 semana

B Bolo endovenoso directo de cloruro de potasio

C Cloruro de potasio endovenoso diluido en solución fisiológica, a no más de 10–20 mEq/h, con monitorización cardíaca, más corregir el magnesio

D Cloruro de potasio diluido en suero glucosado al 5 %

E Insulina con glucosa para mejorar el potasio

Respuesta C. Hipokalemia severa (menor de 2,5 mEq/L) con cambios en el ECG: KCl endovenoso diluido en suero fisiológico, máximo 10–20 mEq/h por vía periférica, con monitorización, suspendiendo la tiazida y corrigiendo el magnesio. El suero glucosado libera insulina y empeora la hipokalemia; el bolo directo puede causar paro.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 56 años, hipertensa, que cambió hidroclorotiazida por clortalidona a dosis plenas. Consulta por astenia, calambres y palpitaciones. ECG: T aplanadas, ondas U en V2–V4 y extrasístoles ventriculares aisladas. K 2,8 mEq/L, Mg 1,4 mg/dL (VN 1,8–2,4). Se inicia KCl periférico a 10 mEq/h. A las 24 horas, con 80 mEq acumulados, el K es 2,9 mEq/L. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Aumentar el KCl periférico a 40 mEq/h

B Administrar sulfato de magnesio endovenoso

C Cambiar el vehículo a suero glucosado al 5%

D Agregar furosemida

E Suspender el aporte y controlar en 48 horas

Respuesta B. Hipokalemia por tiazida, refractaria a un aporte adecuado, con magnesio bajo: la hipomagnesemia libera el canal ROMK y el potasio se pierde por la orina. Se repone sulfato de magnesio IV. Subir a 40 mEq/h supera el límite periférico, y el suero glucosado empeora la hipokalemia.

▶ VER CLASE 1.09.2.007

Hiponatremia aguda grave

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 2.1 · Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica
Nefrología 2.2 · SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Hiponatremia aguda (<48 h) o con síntomas graves: convulsiones, estupor, coma o bradipnea por edema cerebral, con riesgo de enclavamiento.
- Confirmar hipotonía (Osm <275) y buscar causa: postoperatorio, polidipsia, éxtasis, tiazidas + ISRS, SIADH.
- Tratamiento: NaCl 3% 100–150 mL en bolo de 10–20 minutos; repetir hasta 2 veces más cada 20–30 min si persisten los síntomas.
- Meta: subir 4–6 mEq/L (basta para revertir el edema), sin superar 8–10 mEq/L en 24 h (6–8 en alto riesgo); natremia cada 4–6 h.
- Sobrecorrección o poliuria acuosa tras el suero: SG 5% + desmopresina 1–2 mcg para re-descender; la desmielinización osmótica aparece a los 2–6 días (disartria, disfagia, cuadriparesia).
- Seguimiento: hospitalizar y derivar a unidad de paciente crítico y nefrología o endocrinología.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 92

Un paciente de 72 años, fumador de 40 paquetes/año, con diagnóstico de cáncer pulmonar de células pequeñas sin tratamiento actual, presenta un cuadro de 7 días de evolución de cefalea y tendencia a la desorientación. En sus exámenes destaca una concentración sérica de sodio de 121 mEq/L, sin focalidad neurológica. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A SIADH (Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética)

B Metástasis cerebrales

C Síndrome carcinoide

D Accidente vascular encefálico

E Hipercalcemia

Respuesta A. SIADH clásico por cáncer pulmonar de células pequeñas, con hiponatremia y compromiso neurológico. Con síntomas neurológicos se usa salino hipertónico lento; si no, restricción de agua libre.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 92

Un paciente de 72 años, fumador de 40 paquetes-año, con diagnóstico de cáncer pulmonar de células pequeñas sin tratamiento actual, presenta un cuadro de 7 días de evolución de cefalea y tendencia a la desorientación. En sus exámenes destaca una concentración sérica de sodio de 121 mEq/L, sin focalidad neurológica. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A SIADH (síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética)

B Metástasis cerebrales

C Síndrome carcinoide

D Accidente vascular encefálico

E Hipercalcemia

Respuesta A. El carcinoma de células pequeñas es la causa paraneoplásica clásica de SIADH. Hiponatremia de 121 mEq/L con cefalea y desorientación, sin focalidad, explica el cuadro. Las metástasis cerebrales suelen dar focalidad y la hipercalcemia paraneoplásica se asocia más al carcinoma escamoso.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 74 años, hipertensa y deprimida, en tratamiento con hidroclorotiazida 25 mg/día y citalopram 20 mg/día. Hace 30 minutos tuvo una convulsión tónico-clónica generalizada. Está en sopor moderado, PA 135/85 mmHg, sin deshidratación ni edema. Glicemia 98 mg/dL, Na 112 mEq/L, K 3,6 mEq/L, Osm plasmática 232 mOsm/kg. Na urinario 68 mEq/L, Osm urinaria 410 mOsm/kg. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Restricción hídrica a 800 mL/día y suspender los fármacos

B Suero fisiológico 0,9% a 250 mL/hora

C Bolo de NaCl 3%, 100 a 150 mL en 20 minutos

D Furosemida 40 mg intravenosa

E NaCl 3% hasta normalizar el sodio en 24 horas

Respuesta C. Hiponatremia hipotónica euvolémica grave (tiazida + ISRS) con convulsión: encefalopatía hiponatrémica. Se indica bolo de NaCl 3% para subir el sodio 4–6 mEq/L y revertir el edema cerebral. La restricción hídrica es para el SIADH asintomático. Normalizar el sodio en 24 horas supera el límite de 8–10 mEq/L y arriesga desmielinización osmótica.

▶ VER CLASE | 1.09.2.008 | **Hipovolemia** | DX ESPECÍFICO | TX COMPLETO | SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 2.4 · Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipovolemia: pérdidas digestivas, renales (diuréticos), hemorragia o tercer espacio; clínica de mucosas secas, ortostatismo, taquicardia, llene capilar lento, oliguria.
- Laboratorio: BUN/creatinina >20, Na urinario <20 (si no usa diuréticos), hemoconcentración; puede haber IRA prerrenal.
- Reponer con cristaloide isotónico (suero fisiológico 0,9% o Ringer lactato) en bolos de 500–1.000 mL según respuesta; en shock con hipernatremia igual primero el cristaloide.
- El SG 5% no reanima (solo 8% queda intravascular). Grandes volúmenes de suero fisiológico producen acidosis hiperclorémica: preferir Ringer lactato en shock séptico y deshidratación severa.
- Suspender diuréticos, IECA/ARA-II y AINE mientras está hipovolémico; corregir potasio y sodio después de restaurar la volemia.
- Seguimiento completo: diuresis, PA, creatinina y electrolitos hasta normalizar; tratar la causa.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 31

Un paciente de 70 años, diabético tipo 2 e hipertenso, en tratamiento con metformina, losartán e hidroclorotiazida, presenta un cuadro de 4 días de vómitos alimentarios y diarrea, evolucionando con malestar general y disminución del volumen urinario. Al examen físico está bradipsíquico, con presión arterial de 100/50 mmHg, frecuencia cardíaca de 110x'. En sus exámenes de laboratorio destaca creatinina: 2,0 mg/dl, BUN: 78 mg/dl, FeNa: 0,5%, sodio: 130 mEq/L, potasio: 2,0 mEq/L y cloro: 110 mEq/L. **¿Qué fluido debe administrarse inicialmente?**

A Solución glucosada al 5%

B Solución ringer lactato

C Albúmina al 5%

D Solución glucosalina isotónica

E Solución de bicarbonato al 2/3 molar

Respuesta B. IRA prerrenal por hipovolemia (FeNa 0,5 %, BUN/Cr 39) en un usuario de ARA-II y tiazida. Lo primero es reponer la volemia con un cristaloide isotónico; el suero fisiológico no estaba entre las opciones, y el Ringer lactato es la alternativa correcta. La glucosada no expande el intravascular.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 147

Una paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con hidroclorotiazida, presenta un cuadro de diarrea y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está en sopor profundo, con PA: 80/50 y frecuencia cardiaca de 120x', regular, con sequedad de mucosas. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran natremia: 156 mEq/L, cloremia: 114 mEq/L, potasemia: 3,1 mEq/L, pH: 7,40, bicarbonato: 14 mmol/L, CO2: 20 mmHg. **¿Cuál de los siguientes fluidos se debe administrar en primer lugar?**

A Suero glucosado al 5% ev

B Suero fisiológico al 0,9% ev

C Solución de bicarbonato al 2/3 molar ev

D Agua por sonda nasogástrica

E Sales de rehidratación oral

Respuesta B. Paciente en shock hipovolémico: primero se repone la volemia con un cristaloide isotónico, y después se corrige la hipernatremia. El suero glucosado es hipotónico y no expande el intravascular; la vía oral o enteral no es opción en un paciente en sopor.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años hospitalizado por deshidratación severa, reanimado solo con 6 litros de suero fisiológico 0,9% en 24 horas. Hoy está estable. Na 142 mEq/L, Cl 118 mEq/L, HCO3 16 mEq/L, glicemia 110 mg/dL, lactato normal, cetonemia negativa. **¿Cuál es la causa más probable de su alteración ácido-base?**

A Acidosis metabólica hiperclorémica por el suero fisiológico

B Acidosis láctica por hipoperfusión

C Cetoacidosis diabética

D Alcalosis metabólica por contracción de volumen

E Acidosis por uremia

Respuesta A. Anion gap = 142 − (118 + 16) = 8: acidosis metabólica con anion gap normal y cloro alto tras grandes volúmenes de SF 0,9% (154 mEq/L de cloro). Lactato y cetonas normales descartan las acidosis con anion gap elevado. El Ringer lactato habría evitado este efecto.

▶ VER CLASE **1.09.2.009** **Insuficiencia renal aguda obstructiva** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 1.1 · Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca

QUÉ HAY QUE SABER

- IRA postrenal: primera causa reversible a descartar ante toda IRA; sospechar en hombre con prostatismo, globo vesical, anuria, cáncer pélvico o monorreno con cálculo.
- Examen: masa hipogástrica mate y dolorosa; ecografía renal y vesical con hidronefrosis bilateral (o unilateral en monorreno).
- Obstrucción baja: sonda vesical (diagnóstica y terapéutica) con medición del residuo; si hay trauma uretral, cistostomía suprapúbica.
- Obstrucción alta: descompresión urológica con catéter doble J o nefrostomía percutánea si no pasa el doble J; urgencia si hay infección o monorreno.
- Tras descomprimir vigilar poliuria postobstructiva, hipovolemia e hipokalemia. Diuréticos y contraste no tienen lugar.
- Seguimiento: derivar a urología para tratar la causa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 79 años con síntomas prostáticos de años, consulta por 2 días de goteo urinario, dolor hipogástrico y confusión leve. PA 150/90 mmHg. Al examen: masa hipogástrica suprapúbica mate y dolorosa. Creatinina 3,1 mg/dL (basal 1,1 hace 3 meses), K 5,3 mEq/L. **¿Cuál es la primera conducta?**

A Furosemida 40 mg IV

B Hidratación con 2 litros de suero fisiológico

C Hemodiálisis de urgencia

D Pielografía de eliminación

E Instalar sonda vesical y medir el residuo

Respuesta E. El globo vesical en un hombre con prostatismo indica obstrucción baja: la sonda vesical es diagnóstica y terapéutica, y suele revertir la falla renal. Después se vigila la poliuria posobstructiva. Los diuréticos y el contraste no tienen lugar.

▶ VER CLASE 1.09.2.010 Insuficiencia renal aguda prerrenal

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 1.1 · Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca

QUÉ HAY QUE SABER

- IRA (KDIGO): creatinina sube ≥0,3 mg/dL en 48 h, ≥1,5 veces la basal en 7 días o diuresis <0,5 mL/kg/h por 6 h. Estadios 1–3.
- Prerrenal: hipovolemia o hipoperfusión, agravada por AINE (bloquean la dilatación aferente) e IECA/ARA-II (la contracción eferente), sobre todo con diuréticos.
- Índices: FeNa <1%, Na urinario <20, BUN/creatinina >20, Osm urinaria >500 y densidad >1.020; sedimento con cilindros hialinos. Con diuréticos usar FeUrea <35%.
- Primero descartar obstrucción (ecografía, globo). Luego cristaloides isotónicos en bolos de 500–1.000 mL y suspender AINE, IECA/ARA-II, diuréticos y aminoglucósidos.
- Metas: PAM ≥65 mmHg, diuresis horaria con Foley si está inestable; nunca furosemida para forzar diuresis.
- Seguimiento completo: creatinina y diuresis hasta recuperar la basal; reiniciar fármacos con cautela. Si no revierte con volumen, pensar en necrosis tubular.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años, hipertenso y diabético, usuario de enalapril 20 mg/día e hidroclorotiazida 25 mg/día. Consulta por 4 días de diarrea acuosa profusa y vómitos. Somnoliento, PA 85/50 mmHg, FC 115 lpm, mucosas secas, llene capilar de 4 s. Creatinina 3,4 mg/dL (basal 1,0 hace 1 mes), BUN 72 mg/dL, K 5,6 mEq/L. Sodio urinario 12 mEq/L; FeNa 0,3 %. Sedimento: algunos cilindros hialinos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Furosemida 40 mg IV para restablecer la diuresis

B Suspender enalapril e hidroclorotiazida e hidratar con suero fisiológico 0,9 % IV

C Restringir el aporte hídrico a pérdidas insensibles más diuresis

D Hemodiálisis de urgencia por creatinina mayor de 3 mg/dL

E Biopsia renal percutánea

Respuesta B. IRA KDIGO estadio 3 (creatinina 3,4 veces la basal) prerrenal: hipovolemia en un usuario de IECA y diurético. FeNa < 1 %, Na urinario < 20, BUN/Cr ≈ 21 y cilindros hialinos. Se suspenden IECA y diurético y se expande con cristaloides isotónicos. La furosemida agravaría el shock; la restricción hídrica es para la necrosis tubular establecida.

▶ VER CLASE 1.09.2.011 Pielonefritis aguda complicada

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 5.4 · Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto
Obstetricia 19.9 · Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Pielonefritis complicada: embarazo, obstrucción o litiasis, sepsis, intolerancia oral, falla renal, diabetes descompensada, inmunosupresión, hombre o anomalía urológica.
- Todas se hospitalizan; urocultivo y hemocultivos antes del antibiótico.
- Tratamiento: ceftriaxona 1–2 g IV c/24 h; BLEE o shock séptico: ertapenem 1 g/día o meropenem; pasar a oral tras 48 h afebril y completar 10–14 días según antibiograma.
- Embarazada: hospitalizar siempre, ceftriaxona o cefazolina IV, nunca ciprofloxacino; urocultivo de control y profilaxis nocturna hasta el parto.
- Con obstrucción por cálculo (pionefrosis): emergencia urológica, descompresión con doble J o nefrostomía. Sin respuesta a 48–72 h con germen sensible: TAC para absceso u obstrucción.
- Seguimiento completo: ajuste por antibiograma, control clínico y de función renal; derivar a urología si hay causa estructural.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 8

Una paciente de 28 años, cursando un embarazo de 18 semanas, consulta por cuadro de fiebre, malestar general, náuseas, disuria dolorosa y dolor lumbar derecho. Al examen físico, tiene fiebre de 38,9°C, frecuencia cardíaca 95x', presenta puño percusión positiva a derecha. Se solicitan exámenes de orina que muestran sedimento con 20 glóbulos rojos por campo, 50 leucocitos por campo y abundantes bacterias, estando pendiente el resultado del urocultivo. Las pruebas de bienestar fetal no muestran alteraciones. **¿Qué tratamiento antibiótico es el más adecuado para su manejo?**

A Ciprofloxacino
B Nitrofurantoína
C Amoxicilina más ácido clavulánico
D Ceftriaxona
E Ampicilina

Respuesta D. PNA en el embarazo: hospitalización y antibiótico intravenoso, de elección ceftriaxona. El ciprofloxacino está contraindicado en el embarazo y la nitrofurantoína solo sirve para la infección urinaria baja (no alcanza el parénquima renal).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 8

Paciente de 28 años, cursando un embarazo de 18 semanas, consulta por fiebre, malestar general, náuseas, disuria dolorosa y dolor lumbar derecho. Tiene fiebre de 38,9 grados, frecuencia cardíaca de noventa y cinco por minuto, y puñopercusión positiva a derecha. El sedimento de orina muestra abundantes bacterias y leucocitos, con el urocultivo pendiente. Las pruebas de bienestar fetal son normales. **¿Qué tratamiento antibiótico es el más adecuado?**

A Ciprofloxacino
B Nitrofurantoína
C Amoxicilina más ácido clavulánico
D Ceftriaxona
E Ampicilina

Respuesta D. Fiebre alta con puñopercusión positiva en el embarazo es pielonefritis aguda: se hospitaliza y se trata con cefalosporina endovenosa, ceftriaxona o cefazolina. La nitrofurantoína solo sirve para infección urinaria baja, y el ciprofloxacino está contraindicado.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 50 años hospitalizado por PNA derecha, con ceftriaxona 1 g IV cada 24 h desde hace 72 h. Persiste con fiebre diaria de 39 °C y dolor lumbar en aumento. Leucocitos 17.000/mm³, PCR en ascenso. Urocultivo: E. coli sensible a cefalosporinas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Cambiar a vancomicina IV
B Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste
C Suspender antibióticos y repetir hemocultivos en 48 h
D Alta con ciprofloxacino oral por 21 días
E Mantener el mismo esquema y controlar en 7 días

Respuesta B. Sin respuesta a las 48–72 h de un antibiótico al que el germen es sensible: hay que descartar una complicación local (absceso renal o perirrenal, obstrucción litiásica). El examen de elección es el TAC con contraste; la conducta depende de lo que muestre (drenaje o descompresión).

▶ VER CLASE 1.09.2.012 Pre eclampsia

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.5 · Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad

QUÉ HAY QUE SABER

- Preeclampsia: PA ≥140/90 después de las 20 semanas con proteinuria ≥300 mg/24 h (o IPC ≥0,3) o, sin proteinuria, daño de órgano (plaquetas, transaminasas, creatinina).
- Signos de severidad: PA ≥160/110, cefalea, fotopsias, epigastralgia, oliguria, edema pulmonar, trombocitopenia, alza de transaminasas o creatinina (HELLP).
- Estudio: hemograma con plaquetas, pruebas hepáticas, creatinina, ácido úrico, proteinuria y ecografía Doppler fetal.
- Antihipertensivos: labetalol, metildopa o nifedipino oral; IECA y ARA-II contraindicados. Con severidad: sulfato de magnesio para prevenir eclampsia.
- Interrumpir a las 37 semanas la preeclampsia sin severidad; la severa se hospitaliza y se interrumpe según madurez y estabilidad (habitualmente a las 34 semanas o antes si empeora).
- Seguimiento: derivar a alto riesgo obstétrico; en población de riesgo, aspirina en dosis baja desde antes de las 16 semanas como prevención.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Primigesta de 34 semanas, sin antecedentes, presenta PA 148/96 mmHg confirmada en 2 tomas separadas por 4 horas. Está asintomática. Plaquetas, transaminasas y creatinina normales. **¿Cuál de los siguientes hallazgos confirma preeclampsia?**

A Proteinuria de 150 mg en orina de 24 horas

B Edema de extremidades inferiores

C Ácido úrico de 5 mg/dL

D Aumento de peso de 2 kg en una semana

E Proteinuria de 350 mg en orina de 24 horas

Respuesta E. La preeclampsia es hipertensión de inicio después de las 20 semanas con proteinuria de 300 mg o más en 24 horas (o índice proteinuria/creatininuria de 0,3 o más) o, sin proteinuria, compromiso de órgano blanco. El edema y el alza de peso no son criterios diagnósticos. El ácido úrico puede elevarse, pero no define el cuadro.

▶ VER CLASE 1.09.2.013

Vasculitis o glomerulonefritis rápidamente progresiva

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 4.4 · Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA

Reumatología 9.22 · Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

QUÉ HAY QUE SABER

- GNRP: síndrome nefrítico activo con pérdida de >50% de la TFG en días a semanas; en la biopsia, semilunas en >50% de los glomérulos (celulares reversibles, fibrosas no).
- Típico en adulto mayor con síntomas generales (astenia, baja de peso, febrícula, anemia, VHS alta) y alza rápida de creatinina con acantocitos y cilindros hemáticos.
- Tipo 1 anti-MBG (lineal; con hemorragia alveolar = Goodpasture), tipo 2 inmunocomplejos (granular, C3 bajo: lupus, postinfecciosa, endocarditis, crioglobulinemia), tipo 3 pauciinmune ANCA (60%, la más frecuente).
- ANCA-p (anti-MPO): poliangeítis microscópica, riñón-pulmón sin vía aérea alta. ANCA-c (anti-PR3): granulomatosis con poliangeítis, sinusitis destructiva, nariz en silla de montar, nódulos cavitados.
- Emergencia: hospitalizar, biopsia urgente sin postergar tratamiento; pulsos de metilprednisolona 500–1.000 mg/día × 3 días + ciclofosfamida o rituximab, cotrimoxazol profiláctico; plasmaféresis en anti-MBG o hemorragia alveolar.
- Seguimiento: derivar de inmediato a nefrología.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 164

Un paciente de 71 años presenta desde hace dos meses malestar general, mialgias y febrícula ocasional, además de episodios de hematuria, especialmente en el último tiempo. Al examen físico, presenta frecuencia cardíaca 82 latidos por minuto, presión arterial 176/111 mmHg, edema bimaleolar y disminución del volumen de orina. El examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en dos tiempos sin soplos y murmullo pulmonar presente con crépitos bibasales, sin otros ruidos. En los exámenes de laboratorio destacan creatininemia: 4,34 mg/dL, BUN: 72 mg/dL, sedimento de orina: 10 leucocitos por campo y 60 hematíes por campo, con 10% de acantocitos. **¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A Anticuerpos antinucleares (ANA)

B Biopsia renal

C Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA)

D UroTAC

E Electroforesis de proteínas en orina

Respuesta B. Adulto mayor con síntomas generales, nefrítico y falla renal que progresa: GNRP, probablemente por poliangeítis microscópica. Los ANCA orientan, pero el examen que confirma el diagnóstico de GNRP es la biopsia renal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 44

Una paciente de 67 años, presenta un cuadro de malestar general, asociado a febrículas y edema de las extremidades inferiores. Al examen físico, su presión arterial es 180/110 mmHg y se constata el edema blando, con signo de la fóvea. En sus exámenes de sangre destaca creatininemia de 4,1 mg/dl, BUN de 60 mg/dl y sedimento de orina con 60 eritrocitos por campo, con 80% de dismorfia y leucocitos de 10 a 15 por campo y cilindros hemáticos. Su hemograma muestra hemoglobina: 11,8 mg/dl, hematocrito: 36%, blancos: 10.000 por mm3, plaquetas: 160.000 por mm3. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Glomerulonefritis postestreptocócica

B Nefropatía diabética

C Lesión glomerular mínima

D Vasculitis ANCA positiva

E Púrpura trombocitopénico trombótico

Respuesta D. Adulta mayor con síntomas generales, nefrítico (dismorfia, cilindros hemáticos, HTA) y creatinina de 4,1: GNRP, cuya causa más frecuente a esta edad es la vasculitis ANCA (poliangeítis microscópica). Plaquetas normales descartan el PTT.

PREGUNTA REAL · EUNACOM · RESCATE Y PROFILAXIS EN VASCULITIS ANCA SEVERA

Paciente de 40 años diagnosticado de Granulomatosis con Poliangeítis con compromiso renal severo y hemorragia alveolar difusa con requerimiento de ventilación mecánica invasiva. Se inicia tratamiento con bolos de metilprednisolona EV y Rituximab. Con respecto a las medidas complementarias de rescate y profilaxis infecciosa, ¿cuál de las siguientes combinaciones de conductas terapéuticas es la más adecuada?

A Indicar plasmaféresis de rescate y profilaxis obligatoria con Cotrimoxazol oral

B Indicar hemodiálisis peritoneal profiláctica e iniciar aciclovir endovenoso continuo

C Administrar heparina en infusión continua a dosis plenas por riesgo de trombosis pulmonar

D Realizar traqueostomía inmediata e indicar ceftriaxona en monoterapia

E Suspender los corticoides por riesgo de sobreinfección fúngica e iniciar ciclosporina

Respuesta A. En pacientes con vasculitis ANCA y falla orgánica crítica caracterizada por hemorragia alveolar difusa con hipoxemia grave, la plasmaféresis (recambio plasmático) remueve rápidamente los anticuerpos patógenos de la circulación. Asimismo, todo paciente que recibe terapia de inducción inmunosupresora intensa con corticoides en dosis altas y Rituximab o Ciclofosfamida tiene indicación mandataria de profilaxis contra la neumonía por Pneumocystis jirovecii con Cotrimoxazol.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 71 años con 6 semanas de astenia, baja de 5 kg y febrícula; en los últimos 10 días, orinas oscuras, menor diuresis y edema. PA 176/110 mmHg. Creatinina 4,3 mg/dL (0,9 hace 2 meses). Sedimento: 80 % de acantocitos y cilindros hemáticos; proteinuria 1,8 g/24 h. Hb 9,2 g/dL, VHS 98 mm/h. C3 y C4 normales, ANA negativo, ANCA-p (anti-MPO) positivo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Furosemida y restricción de sodio; controlar C3 en 8 semanas

B Hospitalizar, biopsia renal urgente y pulsos de metilprednisolona + ciclofosfamida o rituximab

C Prednisona oral 20 mg/día ambulatoria

D Hemodiálisis crónica sin inmunosupresión

E Solo IECA y control en 3 meses

Respuesta B. Creatinina de 0,9 a 4,3 en semanas + nefrítico activo + ANCA-p con complemento normal: GNRP pauciinmune por poliangeítis microscópica. Es una emergencia: hospitalizar, biopsia urgente e inducción inmediata con pulsos de metilprednisolona más ciclofosfamida o rituximab.

Conocimientos generales

11 códigos

▶ VER CLASE `1.09.3.001` **Ajuste de fármacos según función renal**

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.5 · Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible

QUÉ HAY QUE SABER

- Calcular siempre la TFG estimada (CKD-EPI; Cockcroft-Gault para dosis) antes de prescribir; la creatinina normal puede ocultar TFG baja en adultos mayores con poca masa muscular.
- Metformina: mantener con TFG 45–59 (vigilar cada 6 meses), reducir al 50% (máximo 1.000 mg/día, no iniciar) con TFG 30–44 y suspender con TFG <30 por acidosis láctica.
- Alternativas en diabéticos con ERC: insulina o inhibidor DPP-4 (linagliptina no requiere ajuste); evitar glibenclamida por hipoglicemias.
- Aminoglucósidos: espaciar según clearance y niveles con TFG <60. Enoxaparina: reducir al 50% con TFG <30 o usar heparina no fraccionada.
- AINE contraindicados en ERC o IRA; ajustar también antibióticos de eliminación renal y evitar contraste yodado innecesario.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 66 años con DM2 en tratamiento con metformina 850 mg cada 8 horas. Asintomático. En sus controles, TFG estimada estable en 38 mL/min/1,73 m² en dos mediciones. HbA1c 7,0 %. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la metformina?**

A Suspenderla e iniciar insulina

B Reducir la dosis a un máximo de 1.000 mg al día

C Mantener la dosis actual y controlar en 1 año

D Aumentar la dosis para compensar la menor eliminación

E Reemplazarla por glibenclamida

Respuesta B. Con TFG entre 30 y 44 mL/min la metformina no se suspende: se reduce la dosis máxima al 50 % (máximo 1.000 mg/día) y se monitoriza la función renal. La suspensión es obligatoria recién con TFG < 30.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 70 años con diabetes mellitus en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas acude a control. Sus exámenes revelan creatinina de 2.2 mg/dL con filtrado glomerular estimado en 25 mL/min/1.73m². La paciente está asintomática. **¿Cuál es la conducta farmacológica correcta respecto al manejo de su diabetes?**

A Suspender la metformina de inmediato e indicar una alternativa terapéutica segura

B Aumentar la metformina a 850 mg cada 8 horas para compensar la menor eliminación

C Mantener la metformina en la misma dosis y asociar hidroclorotiazida

D Agregar glibenclamida a dosis plenas

E Suspender todos los fármacos y dejarla únicamente con dieta

Respuesta A. Con TFG < 30 mL/min la metformina se acumula y puede causar acidosis láctica (mortalidad > 40 %). Se suspende de inmediato y se reemplaza por insulina o un inhibidor de DPP-4 ajustado a la función renal.

▶ VER CLASE 1.09.3.002 Control de factores de riesgo de enfermedad vascular

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.4 · Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

QUÉ HAY QUE SABER

- Estratificar el riesgo cardiovascular global antes de fijar metas (Programa de Salud Cardiovascular, MINSAL).
- Riesgo muy alto (evento ateroesclerótico previo, diabético con daño de órgano blanco, ERC con TFG <45): c-LDL <55 mg/dL o <70 según guía MINSAL y reducción ≥50%; estatina de alta intensidad (atorvastatina 40–80 o rosuvastatina 20–40 mg).
- Riesgo alto: c-LDL <70; moderado: <100; bajo: estilo de vida. Si no se alcanza la meta con dosis máxima: agregar ezetimiba 10 mg.
- PA <140/90 (o <130/80 en diabéticos y ERC), HbA1c individualizada, dejar el tabaco, ejercicio, dieta con sal <5 g/día y control del peso.
- Mialgias por estatinas: medir CK; CK 3–10 veces: miositis, suspender; >10 veces con orina oscura: rabdomiólisis. Reintroducir con dosis menor o rosuvastatina/pravastatina.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años con DM2, hipertensión y tabaquismo activo, sin eventos cardiovasculares previos, tiene colesterol LDL de 132 mg/dL. Se clasifica como de riesgo cardiovascular alto. **¿Cuál es la meta de colesterol LDL más adecuada para este paciente?**

A Menor de 190 mg/dL

B Menor de 160 mg/dL

C Menor de 130 mg/dL

D Menor de 70 mg/dL

E No requiere meta de LDL, solo control glicémico

Respuesta D. En pacientes de riesgo cardiovascular alto, como diabéticos con otros factores de riesgo, la meta de LDL es menor de 70 mg/dL, idealmente con una reducción de al menos 50%, usando estatinas de alta intensidad. El control integral de factores de riesgo incluye cesación tabáquica, control de presión y glicemia; dejar de fumar es la medida aislada de mayor impacto.

▶ VER CLASE 1.09.3.003 Desnutrición en insuficiencia renal crónica

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.2 · Complicaciones de la ERC: Anemia, Trastorno Mineral Óseo (CKD-MBD) y Acidosis

QUÉ HAY QUE SABER

- La desnutrición calórico-proteica es frecuente en la ERC avanzada y en diálisis (anorexia urémica, acidosis, inflamación, pérdidas dialíticas) y predice mortalidad.
- Evaluar peso, IMC, albúmina (<3,5 g/dL es mal pronóstico), ingesta y masa muscular en cada control.
- Antes de diálisis (G3–G5): proteínas 0,6–0,8 g/kg/día con aporte calórico suficiente, sodio <2 g/día y restricción de fósforo y potasio según exámenes.
- En hemodiálisis o peritoneodiálisis aumentar las proteínas a 1,0–1,2 g/kg/día, manteniendo restricción de sodio, potasio, fósforo y líquidos.
- Corregir la acidosis metabólica (aumenta el catabolismo) y derivar a nutricionista para plan individual.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 66 años en hemodiálisis trisemanal hace 2 años presenta baja de peso, albúmina 3,1 g/dL e inapetencia. Mantiene una dieta con restricción proteica de 0,6 g/kg/día indicada antes de iniciar diálisis. **¿Cuál es la recomendación proteica más adecuada en esta etapa?**

A Aumentar a 1,0-1,2 g/kg/día

B Reducir a 0,4 g/kg/día

C Mantener 0,6 g/kg/día

D Dieta sin proteínas los días de diálisis

E Eliminar toda restricción de sodio y potasio

Respuesta A. La desnutrición calórico-proteica es frecuente en la ERC y predice mortalidad. Antes de diálisis se indica una restricción moderada (0,6-0,8 g/kg/día) para retardar la progresión, pero en hemodiálisis la pérdida de aminoácidos y el catabolismo obligan a aumentar a 1,0-1,2 g/kg/día, manteniendo restricción de sodio, potasio, fósforo y líquidos.

▶ VER CLASE 1.09.3.004 Diálisis y complicaciones

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 1.3 · Síndrome Urémico y Urgencias Dialíticas (Criterios AEIOU)
Nefrología 5.1 · Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Terapias de reemplazo en ERC G5 (GES N° 1): hemodiálisis 3 veces por semana por 4 horas, peritoneodiálisis o trasplante renal.
- Acceso de elección: fístula arteriovenosa autóloga radiocefálica en brazo no dominante, confeccionada ≥6 meses antes; evitar catéteres centrales (bacteriemia, estenosis). Catéter de urgencia en yugular interna derecha.
- Síndrome de desequilibrio dialítico: cefalea, vómitos, confusión y convulsiones en la primera sesión con urea muy alta; prevenir con sesiones cortas (2 h) y flujo bajo.
- Peritonitis en peritoneodiálisis: efluente turbio con >100 leucocitos/mm³ y >50% PMN; cultivo y antibióticos intraperitoneales; retirar catéter si refractaria o fúngica.
- Otras complicaciones: hipotensión intradiálisis, bacteriemia por catéter, hiperkalemia por sesión omitida, sobrecarga de volumen, anemia y CKD-MBD.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años con enfermedad renal crónica sin control previo, BUN 190 mg/dL y creatinina 14 mg/dL, inicia hemodiálisis de urgencia por catéter con una sesión de 4 horas a flujo alto. Al final de la sesión presenta cefalea intensa, náuseas, vómitos, desorientación y una convulsión generalizada. Glicemia 105 mg/dL, Na 138 mEq/L, K 4,0 mEq/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hipoglicemia por la diálisis

B Síndrome de desequilibrio dialítico

C Hemorragia intracraneana por heparina

D Encefalopatía urémica que no ha respondido

E Embolia gaseosa por el catéter

Respuesta B. En el primer tratamiento con urea muy alta, la remoción rápida crea un gradiente osmótico entre plasma y cerebro, con edema cerebral: cefalea, vómitos, confusión y convulsiones. Se previene con primeras sesiones cortas, de bajo flujo. Glicemia y electrolitos normales descartan las otras causas metabólicas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 57 años en diálisis peritoneal ambulatoria continua hace 2 años. Consulta por 24 horas de dolor abdominal difuso y líquido de drenaje turbio. T° 37,9 °C, abdomen sensible sin signos de perforación. Recuento del efluente: 850 leucocitos/mm³ con 82 % de polimorfonucleares. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tomar cultivo del efluente e iniciar antibióticos intraperitoneales empíricos

B Retirar el catéter peritoneal de inmediato

C Laparotomía exploradora de urgencia

D Cambiar a hemodiálisis y observar sin antibióticos

E Ciprofloxacino oral y control en 1 semana

Respuesta A. Peritonitis asociada a diálisis peritoneal: efluente turbio con más de 100 leucocitos/mm³ y más de 50 % de PMN. Se cultiva el líquido y se inician antibióticos intraperitoneales que cubran grampositivos y gramnegativos. El catéter se retira solo si es refractaria o fúngica.

▶ VER CLASE 1.09.3.005 Función renal en el embarazo

DÓNDE SE ENSEÑA

Obstetricia 19.5 · Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad

QUÉ HAY QUE SABER

- En el embarazo el flujo plasmático renal y la TFG aumentan 40–50%: la creatinina normal baja a ~0,4–0,8 mg/dL; una creatinina de 1,0 ya es anormal.
- Hidroureteronefrosis fisiológica, más a derecha, por progesterona y compresión uterina: favorece la progresión de bacteriuria a pielonefritis.
- Glucosuria fisiológica y proteinuria hasta 300 mg/24 h son normales; ≥300 mg/24 h (IPC ≥0,3) con HTA después de las 20 semanas = preeclampsia.
- Tamizaje con urocultivo en el control prenatal: la bacteriuria asintomática se trata siempre (cefadroxilo 7 días) con urocultivo de control.

- IECA y ARA-II contraindicados (daño renal fetal, oligohidroamnios); evitar AINE y quinolonas. La IRA del embarazo se asocia a preeclampsia/HELLP, hemorragia y sepsis.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Embarazada de 30 semanas, normotensa y asintomática, presenta en exámenes de rutina una creatinina plasmática de 1,0 mg/dL. Antes del embarazo tenía 0,8 mg/dL. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Es normal, porque la creatinina aumenta en el embarazo

B Es esperable por aumento de la masa muscular

C Indica una deshidratación leve sin importancia

D Está elevada para el embarazo y debe estudiarse una alteración de la función renal

E Solo debe repetirse después del parto

Respuesta D. En el embarazo el flujo plasmático renal y la filtración glomerular aumentan cerca de 50%, por lo que la creatinina baja normalmente a 0,4-0,8 mg/dL. Un valor de 1,0 o más, aunque sería normal fuera del embarazo, sugiere deterioro de la función renal y obliga a estudiar preeclampsia, nefropatía u obstrucción.

▶ VER CLASE 1.09.3.006 Higiene para prevención de infección urinaria

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.4 · Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Medidas higiénicas para prevenir ITU recurrente: hidratación abundante y no retener la orina.
- Orinar después de las relaciones sexuales y asearse de adelante hacia atrás.
- Evitar espermicidas y duchas vaginales, que alteran la flora protectora.
- Tratar la constipación y, en niños, la disfunción miccional y la fimosis; en postmenopáusicas, considerar estrógenos vaginales.
- Si fallan (≥3 cistitis/año): profilaxis antibiótica poscoital en dosis única (nitrofurantoína o cotrimoxazol); en portadores de sonda, retirarla lo antes posible.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 24 años ha tenido 4 episodios de cistitis no complicada en el último año, la mayoría 1 a 2 días después de tener relaciones sexuales. Examen físico y ecografía renal normales. **¿Cuál es la medida higiénica de prevención más adecuada?**

A Duchas vaginales diarias

B Orinar después de las relaciones sexuales y mantener buena hidratación

C Usar espermicidas

D Restringir líquidos para orinar menos veces

E Aseo genital de atrás hacia adelante

Respuesta B. En la cistitis recurrente asociada al coito se recomienda orinar después de las relaciones, beber abundantes líquidos, no retener la orina y asearse de adelante hacia atrás. Los espermicidas y las duchas vaginales alteran la flora y aumentan el riesgo. Si las medidas fallan, se considera profilaxis antibiótica poscoital.

▶ VER CLASE 1.09.3.007 Nefrotoxicidad de medicamentos y renoprotección

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.5 · Ajuste de Fármacos en Insuficiencia Renal y Nefrotoxicidad Prevenible

QUÉ HAY QUE SABER

- Nefrotóxicos principales: AINE (cierran la arteriola aferente), aminoglucósidos, vancomicina, anfotericina B, contraste yodado, litio, calcineurínicos.
- Doble o triple golpe: AINE + IECA/ARA-II + diurético en un paciente deshidratado anulan la autorregulación y precipitan IRA prerrenal.
- Nefropatía por contraste: creatinina sube ≥0,3 o ≥50% en 48–72 h; prevenir con hidratación IV isotónica (SF 0,9% 1–1,5 mL/kg/h, 6–12 h antes y después), contraste de baja osmolaridad y menor dosis.
- Suspender AINE (y considerar IECA) 48 h antes del contraste; furosemida, manitol y N-acetilcisteína no protegen.
- Renoprotección: IECA o ARA-II + iSGLT2 en ERC con albuminuria, PA <130/80, evitar nefrotóxicos y ajustar dosis según TFG.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años con antecedente de enfermedad renal crónica estadio 3b (TFG 35 mL/min) debe someterse a una tomografía computarizada de tórax con contraste yodado para etapificación oncológica. **¿Cuál es la medida preventiva de primera línea más efectiva para reducir el riesgo de nefropatía inducida por contraste?**

A Hidratación intravenosa con cristaloides isotónicos (suero fisiológico al 0.9%) antes y después del examen

B Administración de furosemida en bolo antes del medio de contraste

C Hemodiálisis profiláctica inmediatamente después del procedimiento

D Indicar manitol al 20% en infusión continua

E Administración de prednisona oral 50 mg 12 horas antes

Respuesta A. La hidratación IV con cristaloides isotónicos (1–1,5 mL/kg/h, 6–12 h antes y después) es la única profilaxis con evidencia sólida. Furosemida y manitol depletan volumen y agravan la isquemia; los corticoides previenen la alergia al contraste, no la nefropatía.

▶ VER CLASE 1.09.3.008 Prevención de progresión de insuficiencia renal crónica

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.1 · Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- IECA o ARA-II en toda ERC con albuminuria A2–A3, aunque sea normotenso; dilatan la arteriola eferente y bajan la presión intraglomerular.
- Aceptar un alza de creatinina <30% tras iniciarlos; ajustar o pausar si sube >30% o K >5,5. Nunca combinar IECA + ARA-II.
- Agregar iSGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina): reducen 35–40% los eventos renales, con o sin diabetes.
- PA <130/80, control glicémico, estatina (LDL <70), sodio <2 g/día, proteínas 0,6–0,8 g/kg/día en etapas avanzadas, dejar el tabaco.
- Evitar AINE y nefrotóxicos, ajustar fármacos a la TFG, controlar TFG y RAC cada 6–12 meses y derivar con TFG <30 (GES N° 1).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 54 años, DM2 de 14 años e HTA, en tratamiento con metformina 850 mg c/12 h y amlodipino 10 mg/día. Asintomático. PA 142/88 mmHg, retinopatía diabética no proliferativa. HbA1c 7,4 %, creatinina 1,5 mg/dL (TFGe CKD-EPI 52 mL/min/1,73 m²), K 4,2 mEq/L, orina completa normal, RAC 180 mg/g confirmada en 2 tomas. **¿Cuál es la conducta más adecuada para la protección renal?**

A Suspender la metformina e iniciar insulina

B Agregar hidroclorotiazida

C Iniciar IECA o ARA-II más un inhibidor de SGLT2

D Derivar por GES para confección de fístula arteriovenosa

E Mantener el tratamiento y repetir la RAC en un año

Respuesta C. ERC G3a A2 por nefropatía diabética. La albuminuria A2 en un diabético hipertenso es indicación de primera línea de bloqueo del SRAA (enalapril o losartán), que dilata la arteriola eferente y baja la presión intraglomerular, sumado a un inhibidor de SGLT2. La metformina se mantiene con TFG de 52 (se ajusta bajo 45 y se suspende bajo 30). El GES aplica desde TFG < 30.

▶ VER CLASE 1.09.3.009 Terapia diurética

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 2.4 · Fluidoterapia y Terapia Diurética en la Práctica Clínica

QUÉ HAY QUE SABER

- Diuréticos de asa (furosemida): actúan en el cotransportador Na-K-2Cl, eliminan hasta 20–25% del sodio filtrado y funcionan con TFG <30; elección en edema y sobrecarga.
- Tiazidas (hidroclorotiazida, clortalidona): túbulo distal, antihipertensivo de primera línea; pierden eficacia con TFG <30.
- Efectos adversos: asa con hipokalemia, hipomagnesemia, alcalosis e hiperuricemia; tiazidas con hiponatremia, hipokalemia, hipercalcemia, hiperglicemia e hiperuricemia.
- Espironolactona: base del tratamiento de la ascitis cirrótica (100:40 con furosemida), HTA resistente e hiperaldosteronismo; riesgo de hiperkalemia y ginecomastia (eplerenona como alternativa).
- Diabetes insípida nefrogénica por litio: tiazida + amilorida. Vigilar sodio, potasio y función renal en todo paciente con diuréticos.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 60

Un paciente de 78 años, diabético, hipertenso y dislipidémico está en tratamiento con metformina, glibenclamida, enalapril, hidroclorotiazida, aspirina y atorvastatina. Se realiza exámenes de laboratorio, entre los que destacan sodio plasmático: 130 mEq/L, potasio plasmático: 3,4 mEq/L, creatinina plasmática: 1,1 mg/dl. **¿Cuál es la causa más probable de sus alteraciones?**

A Nefroesclerosis hipertensiva
B Uso de hidroclorotiazida
C Nefropatía diabética
D Uso de enalapril
E Uso de aspirina

Respuesta B. Hiponatremia con hipokalemia y función renal normal en un usuario de tiazida: la hidroclorotiazida explica ambas. El enalapril tiende a subir el potasio, no a bajarlo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 56 años con cirrosis alcohólica Child-Pugh B, en abstinencia, consulta por aumento progresivo del perímetro abdominal. Ascitis moderada sin signos de peritonitis; paracentesis diagnóstica con GASA 1,8 g/dL y 90 PMN/mm³. Creatinina 0,8 mg/dL, Na 136 mEq/L, K 4,1 mEq/L. **¿Cuál es el esquema diurético inicial más adecuado, junto a la restricción de sodio?**

A Furosemida 80 mg/día en monoterapia
B Hidroclorotiazida 50 mg/día
C Espironolactona 100 mg/día más furosemida 40 mg/día
D Acetazolamida 250 mg cada 12 horas
E Paracentesis evacuadora semanal sin diuréticos

Respuesta C. En la ascitis cirrótica el motor es el hiperaldosteronismo secundario, por eso la base es la espironolactona; se combina con furosemida en proporción 100:40 para mantener el potasio y acelerar la respuesta. La furosemida sola es poco eficaz y produce hipokalemia, que precipita encefalopatía.

▶ VER CLASE 1.09.3.010 Tratamiento no medicamentoso de la hipertensión arterial

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.3 · Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- Reducir la sal a <5 g/día (~2 g de sodio): baja la PAS 4–5 mmHg; evitar pan, embutidos, caldos en cubo y procesados.
- Bajar de peso: cada 1 kg perdido reduce ~1 mmHg; meta IMC <25 y cintura <90 cm en hombres y <80 cm en mujeres.
- Dieta DASH, rica en frutas, verduras, lácteos descremados y potasio (salvo ERC avanzada).
- Ejercicio aeróbico moderado ≥150 minutos por semana; moderar el alcohol y dejar el tabaco.
- Son la base en todos los hipertensos y la única medida inicial en etapa 1 de bajo riesgo; con PA ≥160/100 se suman fármacos de inmediato.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años con hipertensión etapa 1, IMC 31 kg/m2, sedentario y con alto consumo de pan, embutidos y alimentos procesados, consulta por medidas no farmacológicas. **¿Cuál es la recomendación correcta sobre el consumo de sal?**

A Eliminar totalmente el sodio de la dieta
B Menos de 12 g de sal al día
C Menos de 5 g de sal al día
D La sal no influye en la presión arterial
E Reemplazar la sal por caldo en cubos

Respuesta C. La OMS y el MINSAL recomiendan consumir menos de 5 g de sal al día, cerca de 2 g de sodio, lo que baja la PA sistólica en 4-5 mmHg. También ayudan bajar de peso, la dieta DASH, el ejercicio aeróbico y moderar el alcohol. Los caldos en cubo, los embutidos y el pan son fuentes ocultas de sodio.

▶ VER CLASE 1.09.3.011 Trasplante renal, indicaciones y complicaciones

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.1 · Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- El trasplante renal es la terapia de reemplazo con mejor sobrevida y calidad de vida en ERC G5; está incluido en el GES de ERC terminal.
- Contraindicaciones: cáncer activo, infección activa no controlada, enfermedad cardiovascular grave no corregible, mala adherencia o expectativa de vida corta.
- Inmunosupresión habitual: tacrolimus + micofenolato + prednisona; los calcineurínicos son nefrotóxicos y requieren niveles plasmáticos.
- Infecciones según tiempo: primer mes nosocomiales; 1–6 meses oportunistas (CMV, Pneumocystis: profilaxis con cotrimoxazol al menos 6 meses); después, comunitarias. Pielonefritis del injerto: dolor sobre el injerto y alza de creatinina.
- Otras complicaciones: rechazo (hiperagudo, agudo, crónico), recurrencia de la enfermedad (GEFS), neoplasias (piel, linfoma), diabetes postrasplante y enfermedad cardiovascular.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 103

Paciente con trasplante renal hace 9 años, usuario de tacrolimus, presenta hace 1 semana compromiso del estado general y dolor en la zona del injerto. Los exámenes de rutina de hace 10 días mostraban niveles plasmáticos de tacrolimus en rango normal y creatinina de 0,9 mg/dL. Exámenes actuales: creatinina 2,3 mg/dL y orina completa con leucocitos y bacterias. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Rechazo agudo

B Rechazo crónico

C Intoxicación por tacrolimus

D Pielonefritis del injerto

E Pielonefritis de los riñones nativos

Respuesta D. Dolor sobre el injerto, compromiso general, leucocituria y bacteriuria con alza aguda de creatinina sugieren pielonefritis del injerto, infección frecuente en trasplantados por la inmunosupresión. Requiere urocultivo y antibióticos endovenosos. Con niveles normales de tacrolimus la toxicidad es improbable, el rechazo crónico es lento y el rechazo agudo no explica la piuria.

Exámenes e imagenología

16 códigos

▶ VER CLASE 1.09.4.001 **Angiografia renal** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.3 · Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- Angiografía (arteriografía) renal por sustracción digital: estándar de oro para la estenosis de arteria renal, y permite tratar en el mismo acto (angioplastía).
- Se indica cuando el eco Doppler (primer examen: VSM >180–200 cm/s, índice reno-aórtico >3,5) es positivo o dudoso y se planifica intervenir; angioTAC o angio-RM son alternativas no invasivas.
- Hallazgos: collar de perlas en tercio medio-distal (displasia fibromuscular, mujer joven) o estenosis ostial calcificada (ateroesclerosis, adulto mayor).
- Riesgos: nefropatía por contraste (hidratar, suspender AINE), hematoma o pseudoaneurisma del sitio de punción, ateroembolia.
- El médico general sospecha, pide el Doppler y deriva; emplea el informe para decidir la derivación a angioplastía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 27 años con hipertensión de difícil manejo pese a 3 fármacos. Al examen se ausculta un soplo abdominal paraumbilical. La ecografía doppler sugiere estenosis de la arteria renal derecha. **¿Cuál es el examen de referencia para confirmar el diagnóstico?**

A Renina plasmática

B Cintigrama renal con captopril

C Pielografía de eliminación

D Ecografía renal simple

E Angiografía renal por sustracción digital

Respuesta E. En una mujer joven con HTA resistente y soplo abdominal se sospecha displasia fibromuscular de la arteria renal. La angiografía renal es el examen de referencia: muestra la imagen en collar de perlas y permite tratar con angioplastia en el mismo acto. La angio-TAC y la angio-RM son alternativas no invasivas, y el cintigrama con captopril está en desuso.

▶ VER CLASE 1.09.4.003 **Pielo TAC** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.1 · Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- PieloTAC: TAC de abdomen y pelvis sin contraste; examen de elección en el cólico renal, con sensibilidad y especificidad >95%.
- Muestra cálculos de cualquier composición (incluido ácido úrico), su tamaño, ubicación, densidad (unidades Hounsfield) e hidronefrosis, y diagnósticos diferenciales (aneurisma aórtico, apendicitis, diverticulitis).
- El tamaño informado decide la conducta: <5 mm observar, 5–10 mm tamsulosina, >10 mm LEOC o ureteroscopía; hidronefrosis con fiebre = descompresión urgente.
- No confundir con el uroTAC (con contraste y fase excretora), que se usa para estudiar hematuria.
- En embarazadas y niños se prefiere la ecografía; el seguimiento de cálculos radiopacos puede hacerse con radiografía simple.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 38 años con dolor lumbar izquierdo cólico intenso de inicio súbito, irradiado a la fosa ilíaca y al testículo, con hematuria microscópica. Afebril, con función renal normal. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?**

A Radiografía simple de abdomen

B Pielo TAC (TAC de abdomen y pelvis sin contraste)

C Pielografía de eliminación

D Cintigrama renal

E Resonancia magnética de abdomen

Respuesta B. La pielo TAC, tomografía sin contraste, es el examen de elección en el cólico renal: tiene sensibilidad y especificidad cercanas al 95% y muestra cálculos de cualquier composición, su tamaño y ubicación, la hidronefrosis y diagnósticos diferenciales. La radiografía no ve cálculos radiolúcidos y la pielografía requiere contraste y está en desuso. En embarazadas se prefiere la ecografía.

▶ VER CLASE 1.09.4.004 Radiografía renal y vesical simple

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.1 · Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Radiografía simple renal, ureteral y vesical (de abdomen): cerca del 90% de los cálculos (oxalato y fosfato de calcio, estruvita) son radiopacos.
- Los de ácido úrico son radiolúcidos (no se ven) y la cistina es débilmente opaca: un cálculo visible en TAC y no en la radiografía sugiere ácido úrico.
- Útil para seguir la expulsión de un cálculo radiopaco conocido con menor radiación que repetir TAC, y para ver cálculos coraliformes o nefrocalcinosis.
- No sirve como examen diagnóstico inicial del cólico (baja sensibilidad; superposición de gas, flebolitos y heces): el de elección es la pieloTAC.
- Interpretar: siluetas renales, psoas, imágenes cálcicas en el trayecto ureteral y pelvis, diferenciando flebolitos (redondos, con centro claro).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 55 años con gota tofácea presenta un cólico renal. La pielo TAC muestra un cálculo de 7 mm en el uréter proximal derecho, pero en la radiografía simple renal y vesical no se observan imágenes radioopacas. **¿Cuál es la composición más probable del cálculo?**

A Oxalato de calcio

B Fosfato de calcio

C Estruvita

D Ácido úrico

E Cistina

Respuesta D. Los cálculos de ácido úrico son radiolúcidos: no se ven en la radiografía simple de riñón y vejiga, pero sí en la TAC. Se asocian a gota, hiperuricemia y orina ácida, y pueden disolverse alcalinizando la orina con citrato de potasio. Los cálculos de calcio y la estruvita son radioopacos, y la cistina es débilmente opaca.

▶ VER CLASE 1.09.4.005 Ecografía renal (tamaño, asimetrías, hidronefrosis)

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.1 · Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Primer examen de imagen ante una falla renal de reciente diagnóstico: inocuo y sin contraste.
- Riñones normales de 10–12 cm; pequeños (<9 cm) con corteza delgada e hiperecogénica indican ERC avanzada. ERC con riñones grandes: diabetes, poliquistosis, amiloidosis y VIH.
- Descarta obstrucción (hidronefrosis), la principal causa reversible de IRA; asimetría >1,5 cm sugiere enfermedad renovascular o secuela.
- Caracteriza quistes: simple (anecogénico, pared fina, refuerzo posterior) = alta; complejo (tabiques, calcio, sólido) = TAC y Bosniak; múltiples bilaterales = poliquistosis.
- También muestra cálculos, masas sólidas y residuo vesical; el médico general emplea el informe para decidir derivación.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 48

Un paciente de 28 años, con antecedente de tuberculosis renal tratada a los 16 años, presenta edema blando de extremidades inferiores, mayor en las tardes, e hipertensión arterial de 150/90 mmHg. En sus exámenes destaca creatinina plasmática 2,8 mg/dL, BUN 40 mg/dL, Na+ 132 mEq/L, K+ 5,0 mEq/L y orina completa con proteinuria ++ y sedimento normal. **¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio diagnóstico?**

A Pielografía de eliminación
B Ecografía abdominal
C Índice proteinuria/creatininuria
D Cintigrafía DMSA
E TAC renal

Respuesta B. Ante una falla renal de reciente diagnóstico, la ecografía renal es el examen inicial: riñones pequeños con pérdida de la diferenciación corticomedular indican enfermedad crónica, y además evalúa asimetrías, secuelas de tuberculosis e hidronefrosis. Es inocua, a diferencia de la pielografía y la TAC con contraste. La cintigrafía DMSA puede complementar después.

▶ VER CLASE 1.09.4.006 Ecografía vésico-prostática básica

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.3 · Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP

QUÉ HAY QUE SABER

- Ecografía vésico-prostática: examen de imagen inicial en síntomas urinarios bajos del hombre (HPB).
- Informa volumen prostático (>40 cc orienta a sumar inhibidor de 5-alfa reductasa), lóbulo medio, pared vesical engrosada o trabeculada, divertículos y litiasis vesical.
- Mide el residuo postmiccional: >100–150 mL indica vaciamiento incompleto y riesgo de retención.
- Con riñones incluidos, detecta hidronefrosis por obstrucción baja (indicación de cirugía).
- No diagnostica cáncer de próstata (se usa APE, tacto rectal y RM); el médico general emplea el informe para tratar o derivar a urología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 70 años con síntomas urinarios bajos moderados: chorro débil, nicturia y sensación de vaciado incompleto. Al tacto rectal, la próstata está aumentada de tamaño, lisa y elástica. Función renal normal. **¿Cuál es el examen de imagen más útil en la evaluación inicial?**

A Pielografía de eliminación
B Resonancia magnética de pelvis
C Cistografía miccional
D TAC de abdomen con contraste
E Ecografía vésico-prostática con medición del residuo postmiccional

Respuesta E. En la hiperplasia prostática benigna, la ecografía vésico-prostática estima el volumen prostático, evalúa la pared vesical y la presencia de litiasis, y mide el residuo postmiccional; un residuo significativo (mayor de 100-150 mL) indica vaciamiento incompleto y riesgo de retención. La RM se usa ante sospecha de cáncer, y la TAC y la pielografía no son rutinarias.

▶ VER CLASE 1.09.4.007 Cintigrama renal

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.13 · Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Cintigrama estático con DMSA: estándar para detectar cicatrices renales tras pielonefritis; se realiza 4–6 meses después de la infección para no confundir inflamación aguda con cicatriz.
- Cintigrama dinámico (MAG3 o DTPA) con diurético: evalúa obstrucción (estenosis pieloureteral) y la función diferencial de cada riñón.
- Función diferencial ≤10% con corteza adelgazada en un riñón sintomático = riñón no recuperable (nefrectomía); con función conservada, pieloplastía.
- El renograma con captopril para HTA renovascular está en desuso (reemplazado por eco Doppler y angioTAC).
- Indicado principalmente en pediatría (ITU febril, reflujo vesicoureteral) y por el especialista; el médico general emplea el informe.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 10 meses con una primera pielonefritis aguda por E. coli, tratada con buena respuesta. La ecografía renal fue normal. **¿Cuál es el examen indicado para detectar cicatrices renales y cuándo debe realizarse?**

A Cintigrama renal DMSA, 4 a 6 meses después de la infección

B Cintigrama renal DMSA durante la fase aguda en todos los casos

C Uretrocistografía miccional en las primeras 24 horas

D Pielo TAC de control al terminar el tratamiento

E Urografía de eliminación a los 2 meses

Respuesta A. El cintigrama renal con DMSA es el examen de elección para detectar daño del parénquima renal. Para evaluar cicatrices se realiza 4 a 6 meses después de la pielonefritis, porque antes puede mostrar defectos inflamatorios reversibles. La uretrocistografía busca reflujo vesicoureteral y no se hace en la fase aguda.

▶ VER CLASE 1.09.4.008 Anion gap

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 3.3 · Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia

QUÉ HAY QUE SABER

- Anion gap = Na − (Cl + HCO_3); normal 8–12 mEq/L, formado sobre todo por la albúmina.
- Corregir por albúmina: sumar 2,5 por cada 1 g/dL bajo 4,0 (crítico, nefrótico, cirrótico); sin corregir se esconde un AG elevado.
- AG elevado (se agregó un ácido): cetoacidosis, uremia (ERC G5), acidosis láctica (shock, metformina), salicilatos, metanol y etilenglicol.
- AG normal hiperclorémica (se perdió bicarbonato): diarrea, fístulas, ATR, ERC G3–G4, suero fisiológico masivo; AG urinario negativo en diarrea y positivo en ATR.
- AG alto sin cetosis, lactato ni uremia: calcular brecha osmolar (medida − calculada); >10 mOsm/kg sugiere metanol o etilenglicol.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 52 años con cirrosis alcohólica descompensada y peritonitis bacteriana espontánea. PA 85/50 mmHg. Na 138 mEq/L, Cl 108 mEq/L, HCO3 16 mEq/L, albúmina 2,0 g/dL. pH 7,30, pCO2 32 mmHg. **¿Cuál es la interpretación más adecuada del trastorno ácido-base?**

A Acidosis metabólica con anion gap normal, hiperclorémica

B Alcalosis respiratoria primaria

C Acidosis metabólica con anion gap elevado al corregir por la albúmina

D Acidosis respiratoria aguda

E Trastorno ácido-base ausente

Respuesta C. Anion gap = 138 − (108 + 16) = 14, aparentemente normal. Pero la albúmina es el principal anión no medido: por cada g/dL bajo 4 se suman 2,5. Corregido: 14 + 5 = 19, elevado, compatible con acidosis láctica por hipoperfusión séptica. Sin corregir se pierde el diagnóstico.

▶ VER CLASE 1.09.4.009 Clearence de creatinina

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.1 · Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Clearance de creatinina en orina de 24 h = (creatinina urinaria × volumen) / creatinina plasmática; estima la filtración glomerular.
- Sobreestima la TFG real porque una fracción de la creatinina se secreta en el túbulo proximal, más en ERC avanzada; su principal error práctico es la recolección incompleta.
- Hoy se prefieren las ecuaciones de TFG estimada (CKD-EPI en adultos; Schwartz = 0,413 × talla/creatinina en niños); Cockcroft-Gault se usa para ajustar dosis.
- Útil cuando la masa muscular es extrema (amputados, sarcopenia grave, obesidad mórbida), en embarazo o antes de fármacos de margen estrecho.
- La creatinina normal puede ocultar TFG disminuida en adultos mayores con poca masa muscular: siempre interpretar con TFG estimada.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 60 años con enfermedad renal crónica. Se estima su función renal con el clearance de creatinina en orina de 24 horas y se compara con la filtración glomerular medida por un método de referencia. **¿Por qué el clearance de creatinina tiende a sobreestimar la filtración glomerular real, especialmente en ERC avanzada?**

A Porque la creatinina se reabsorbe en el túbulo

B Porque la creatinina se metaboliza en el hígado

C Porque una fracción de la creatinina se secreta en el túbulo proximal

D Porque la creatinina no se filtra libremente

E Porque la orina de 24 horas siempre se recolecta en exceso

Respuesta C. La creatinina se filtra libremente y, además, se secreta en el túbulo proximal, fracción que aumenta a medida que cae la filtración; por eso el clearance sobreestima la VFG en la ERC avanzada. Su principal error práctico es la recolección incompleta de orina. Hoy se prefieren ecuaciones de estimación como CKD-EPI.

▶ VER CLASE **1.09.4.010** **Electrolitos plasmáticos** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA
Nefrología 3.1 · Hiperkalemia Grave y Algoritmo de Estabilización de Membrana
Nefrología 3.2 · Hipokalemia y Reposición Segura de Potasio

QUÉ HAY QUE SABER

- Rangos: Na 135–145, K 3,5–5,0, Cl 98–106 y HCO_3 22–28 mEq/L; interpretar siempre con volemia, función renal, glicemia y fármacos.
- Hiponatremia: confirmar Osm plasmática; con hiperglicemia corregir el Na. Hipernatremia: déficit de agua libre.
- Hiperkalemia: ECG inmediato; si ECG normal y sin causa (trombocitosis, leucocitosis, hemólisis, torniquete largo) sospechar pseudohiperkalemia y repetir sin torniquete o en plasma heparinizado.
- Hipokalemia con HTA, alcalosis y K urinario >20 sin diuréticos: hiperaldosteronismo primario (relación aldosterona/renina).
- Calcular el anion gap con Na, Cl y HCO_3; cloro alto con HCO_3 bajo = acidosis hiperclorémica (diarrea, suero fisiológico masivo, ATR).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 62 años, asintomático, con policitemia vera y trombocitosis de 1.100.000/mm³. En exámenes de control, K 6,7 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL, HCO3 24 mEq/L. No usa fármacos que eleven el potasio. ECG: ritmo sinusal, sin ondas T picudas ni alteraciones del QRS. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Repetir el potasio en plasma con heparina, sin torniquete prolongado
B Insulina con glucosa IV y salbutamol nebulizado
C Hemodiálisis de urgencia
D Gluconato de calcio IV de inmediato
E Iniciar resinas de intercambio y dieta sin potasio

Respuesta A. Hiperkalemia sin causa, con función renal y ECG normales, en un paciente con trombocitosis extrema: sospechar seudohiperkalemia, porque las plaquetas liberan potasio al coagular la muestra en el tubo. Se confirma midiendo potasio en plasma (tubo heparinizado), que será normal. Tratar sin confirmar es un error.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 44 años con hipertensión arterial de difícil manejo pese a amlodipino 10 mg y losartán 100 mg diarios; no usa diuréticos. Refiere calambres ocasionales. PA 168/102 mmHg. K 3,0 mEq/L, Na 143 mEq/L, HCO3 31 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL. Potasio urinario 45 mEq/L. **¿Cuál es el estudio más adecuado a continuación?**

A Metanefrinas plasmáticas
B Aldosterona y actividad de renina plasmáticas
C Cortisol libre urinario de 24 horas
D Ecografía Doppler renal como único estudio
E TSH y T4 libre

Respuesta B. Hipertensión resistente con hipokalemia espontánea, alcalosis metabólica y pérdida renal de potasio (K urinario mayor de 20 a 30 mEq/L) es la tríada del hiperaldosteronismo primario. El tamizaje es la razón aldosterona/renina. Corregir el potasio antes, porque la hipokalemia falsea la aldosterona.

▶ VER CLASE **1.09.4.011** **Estudio metabólico de urolitiasis** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA
Urología 13.1 · Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado en litiasis de alto riesgo: recurrente, monorreno, niños, cálculos bilaterales o múltiples, de ácido úrico, cistina o estruvita, nefrocalcinosis, hiperparatiroidismo, gota o malabsorción.
- Primer episodio no complicado: estudio básico (calcemia, creatinina, ácido úrico, orina completa) y medidas generales.
- Incluye orina de 24 h (calcio, oxalato, citrato, ácido úrico, sodio, volumen), calcemia, PTH, fósforo, uricemia y análisis del cálculo si se recupera.
- Hallazgo más frecuente: hipercalciuria idiopática (calcemia y PTH normales), seguida de hipocitraturia e hiperoxaluria.
- Según resultado: tiazida en hipercalciuria, citrato de potasio en hipocitraturia o ácido úrico, alopurinol en hiperuricosuria; en todos agua >2,5 L/día y dieta baja en sodio con calcio normal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Distintos pacientes consultan tras expulsar su primer cálculo urinario. **¿En cuál de ellos está indicado un estudio metabólico completo de urolitiasis (orina de 24 horas, calcemia, PTH)?**

A Hombre de 40 años con un primer cálculo de 4 mm expulsado, sin otros antecedentes

B Hombre de 50 años con un único cólico hace 10 años

C Mujer de 35 años monorrena con un primer cálculo

D Mujer de 45 años con un cálculo único sin hidronefrosis

E Ningún paciente con litiasis requiere estudio metabólico

Respuesta C. El estudio metabólico completo se indica en pacientes de alto riesgo: litiasis recurrente, monorrenos, niños, cálculos bilaterales o múltiples, cálculos de ácido úrico, cistina o estruvita, enfermedades asociadas como hiperparatiroidismo, gota o malabsorción, y nefrocalcinosis. En un primer episodio no complicado basta un estudio básico y medidas generales como la hidratación.

▶ VER CLASE 1.09.4.012 Examen de orina y sedimento urinario

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 1.2 · Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Nefritis Túbulo-Intersticial Aguda (NTIA)
Nefrología 4.3 · Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)
Urología 13.15 · Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Tira reactiva: sangre detecta el grupo hemo (hemoglobina y mioglobina); tira positiva sin glóbulos rojos en el sedimento = mioglobinuria (rabdomiólisis) o hemoglobinuria. Nitritos específicos pero poco sensibles.
- Hematuria microscópica: ≥3 glóbulos rojos por campo en 2 de 3 sedimentos; dismorfia >80%, acantocitos >5% y cilindros hemáticos = origen glomerular; coágulos e isomorfismo = urológico.
- Cilindros: hialinos (prerrenal, normal), granulosos pardos con células tubulares (necrosis tubular), leucocitarios (pielonefritis o nefritis intersticial), hemáticos (glomerulonefritis).
- Piuria estéril con cilindros leucocitarios orienta a nefritis intersticial; cuerpos ovales grasos con cruz de Malta, a síndrome nefrótico.
- Hematuria isomórfica en mayor de 50 años o fumador: urocultivo, uroTAC y cistoscopía; glomerular: derivar a nefrología.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

¿Cuál de los siguientes hallazgos, en un paciente con hematuria, permite descartar con mayor certeza el origen glomerular del sangrado? **¿Cuál de los siguientes hallazgos permite descartar el origen glomerular?**

A Presencia de coágulos macroscópicos en la orina emitida

B Orina turbia y espumosa

C Hipertensión arterial asociada

D Microhematuria aislada sin proteinuria

E Hematuria posterior a ejercicio extenuante

Respuesta A. Los coágulos descartan el origen glomerular: el túbulo tiene activador del plasminógeno y uroquinasa que degradan la fibrina. Quien elimina coágulos sangra de la vía urinaria: pelvis renal, uréter, vejiga, próstata o uretra.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 24 años consulta 36 horas después de una competencia de crossfit por mialgias intensas y orina color coca-cola. Creatinina 1,8 mg/dL, CK 48.000 U/L. Orina completa: tira reactiva con sangre +++; sedimento con 0 a 2 glóbulos rojos por campo y cilindros granulosos pigmentados. **¿Cuál es la interpretación del examen de orina?**

A Hematuria glomerular por glomerulonefritis aguda

B Mioglobinuria por rabdomiólisis

C Hemoglobinuria por hemólisis intravascular

D Hematuria de origen urológico

E Error de laboratorio; repetir la muestra

Respuesta B. La tira detecta el grupo hemo, tanto de hemoglobina como de mioglobina. Tira con sangre positiva y sedimento sin glóbulos rojos, con CK muy elevada tras ejercicio extremo, es mioglobinuria por rabdomiólisis. La hemólisis no explica la CK ni las mialgias.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 34 años con hematuria microscópica persistente en 3 exámenes. PA 138/88 mmHg. Creatinina 1,0 mg/dL. Se evalúa el sedimento urinario para definir el origen del sangrado. **¿Cuál de los siguientes hallazgos indica con mayor especificidad un origen glomerular?**

A Cilindros hemáticos

B Hematuria con coágulos

C Leucocituria con piuria

D Cilindros hialinos

E Cristales de oxalato de calcio

Respuesta A. Los cilindros hemáticos se forman en el túbulo con glóbulos rojos que atravesaron el capilar glomerular: son patognomónicos de hematuria glomerular, igual que los acantocitos mayores de 5 %. Los coágulos orientan a sangrado de vía urinaria, donde no hay plasma con actividad anticoagulante.

▶ VER CLASE 1.09.4.013 Holter de presión arterial: conocimientos básicos

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.3 · Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- Monitoreo ambulatorio de PA de 24 horas (MAPA): confirma o descarta HTA cuando la PA de consulta es dudosa o discordante con la domiciliaria.
- Criterios de HTA: promedio de 24 h ≥130/80, diurno ≥135/85 o nocturno ≥120/70 mmHg.
- Detecta HTA de bata blanca (alta en consulta, normal en MAPA), HTA enmascarada (al revés) y ausencia de descenso nocturno (non-dipper, mayor riesgo cardiovascular).
- Útil también para evaluar HTA resistente, hipotensión por fármacos y control del tratamiento.
- El médico general lo solicita y emplea el informe; la automedición domiciliaria con equipo validado es una alternativa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 52 años presenta PA de 152/94 mmHg en 3 consultas médicas. En su casa, con un equipo validado, registra promedios de 122/76 mmHg. No tiene daño de órgano blanco. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar o descartar hipertensión?**

A Ecocardiograma

B Monitoreo ambulatorio de presión arterial (Holter de presión) de 24 horas

C Prueba de esfuerzo

D Iniciar tratamiento sin más estudio

E Fondo de ojo

Respuesta B. La diferencia entre la PA en consulta y en domicilio sugiere hipertensión de bata blanca. El monitoreo ambulatorio de 24 horas confirma el diagnóstico: hay hipertensión con un promedio de 24 horas de 130/80 o más, diurno de 135/85 o más o nocturno de 120/70 o más. También detecta hipertensión enmascarada y ausencia de descenso nocturno.

▶ VER CLASE 1.09.4.014 Nitrogeno ureico (relación bun/creatinina

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 1.1 · Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca

QUÉ HAY QUE SABER

- Relación BUN/creatinina normal ~10–20.
- >20: mayor reabsorción de urea, propia de la IRA prerrenal por hipovolemia; también sube con hemorragia digestiva alta, corticoides y dieta hiperproteica.
- <15: necrosis tubular aguda establecida (con Na urinario alto y FeNa >2%).
- Interpretar junto con Na urinario (<20 prerrenal), FeNa (<1%) y sedimento (cilindros hialinos).
- BUN bajo con creatinina normal: desnutrición o hepatopatía grave; el BUN aislado no sirve para estimar la TFG.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 80 años con vómitos y diarrea de 3 días, mucosas secas y PA 95/60 mmHg. Exámenes: BUN 64 mg/dL, creatinina 1,6 mg/dL (basal 0,9) y sodio urinario 12 mEq/L. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Glomerulonefritis rápidamente progresiva

B Necrosis tubular aguda establecida

C Obstrucción urinaria

D Lesión renal aguda prerrenal por hipovolemia

E Nefritis intersticial aguda

Respuesta D. Una relación BUN/creatinina mayor de 20 (aquí 40) indica mayor reabsorción de urea, propia de la falla prerrenal por hipovolemia, y el sodio urinario bajo 20 confirma la conservación tubular de sodio. La NTA establecida muestra relación menor de 15 y sodio urinario alto. La hemorragia digestiva alta y los corticoides también elevan esta relación.

▶ VER CLASE 1.09.4.015 Proteinuria

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 4.1 · Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas

QUÉ HAY QUE SABER

- Normal <150 mg/24 h. Cuantificar con IPC en muestra aislada (≥0,2 patológico) o RAC (A1 <30, A2 30–300, A3 >300 mg/g); la orina de 24 h ya no es el examen de elección.
- Proteinuria transitoria (ejercicio, fiebre, ITU) u ortostática: repetir en primera orina matinal en reposo antes de etiquetar.
- En diabéticos: RAC anual; confirmar con 2 de 3 muestras alteradas en 3–6 meses.
- >3,5 g/24 h (IPC >3–3,5) con albúmina <3 g/dL = síndrome nefrótico; con hematuria dismórfica y HTA, nefrítico. En embarazo ≥300 mg/24 h (IPC ≥0,3) define preeclampsia.
- Proteinuria persistente: IECA o ARA-II; derivar a nefrología si >1 g/día, rango nefrótico o sedimento activo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 19 años, sano, en examen preocupacional presenta proteínas 1+ en la tira reactiva. La muestra se tomó en la tarde, tras un partido de fútbol. PA 118/72 mmHg, sin edema. Sedimento sin glóbulos rojos ni cilindros. Creatinina 0,8 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Biopsia renal

B Iniciar enalapril para reducir la proteinuria

C Derivar a nefrología como síndrome nefrótico

D Solicitar ANA, C3 y C4

E Repetir el examen en la primera orina de la mañana, en reposo

Respuesta E. En un joven sano la proteinuria aislada suele ser transitoria (ejercicio, fiebre) u ortostática. Se repite en la primera orina matinal: si es negativa, el pronóstico es benigno y no requiere estudio. Solo la proteinuria persistente en reposo merece cuantificación y estudio.

▶ VER CLASE 1.09.4.016 Sodio urinario

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 1.1 · Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca
Nefrología 2.1 · Hiponatremia Hipotónica y Síndrome de Desmielinización Osmótica
Nefrología 2.2 · SIADH vs Síndrome Pierde Sal Cerebral y Polidipsia Primaria

QUÉ HAY QUE SABER

- En la IRA: Na urinario <20 y FeNa <1% = prerrenal (túbulo ávido de sodio); Na urinario >40 y FeNa >2% = necrosis tubular.
- Los diuréticos elevan el Na urinario y la FeNa aunque haya hipoperfusión: usar FeUrea (<35% confirma prerrenal).
- En hiponatremia: Na urinario <20 con hipovolemia = pérdida extrarrenal (diarrea, vómitos); >20 con hipovolemia = pérdida renal (tiazidas, Addison).
- Euvolemia con Na urinario >40 y Osm urinaria >100 = SIADH; Osm urinaria <100 con Na urinario bajo = polidipsia primaria.
- Edema con Na urinario bajo = volumen circulante efectivo bajo (IC, cirrosis): hiponatremia hipervolémica, se trata con restricción y furosemida.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 71 años, hipertensa, usuaria de furosemida 40 mg/día (última dosis esta mañana). Consulta por 5 días de vómitos e ingesta oral escasa. PA 95/60 mmHg con ortostatismo, mucosas secas. Creatinina 2,2 mg/dL (basal 0,8). Sodio urinario 46 mEq/L, FeNa 2,1 %, FeUrea 24 %. Sedimento normal. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Insuficiencia renal prerrenal: la furosemida eleva el sodio urinario y la FeUrea bajo 35 % lo confirma

B Necrosis tubular aguda, porque la FeNa es mayor de 2 %

C Nefritis intersticial aguda por furosemida

D Insuficiencia renal obstructiva

E Síndrome hepatorrenal

Respuesta A. Los diuréticos aumentan el sodio urinario y la FeNa aunque el riñón esté hipoperfundido. En ese caso se usa la fracción excretada de urea: menor de 35 % confirma lo prerrenal. Clínica de hipovolemia y sedimento normal apoyan.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 82 años, autovalente, con 4 días de diarrea acuosa y escasa ingesta de líquidos. Está lúcida, sin focalidad. PA 100/60 mmHg con ortostatismo, mucosas secas. No usa diuréticos. Na 126 mEq/L, K 3,5 mEq/L, glicemia 95 mg/dL, creatinina 1,3 mg/dL. Sodio urinario 9 mEq/L. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?**

A SIADH; restricción hídrica

B Insuficiencia suprarrenal; hidrocortisona

C Pérdida renal de sal; tabletas de NaCl

D Polidipsia primaria; restricción de agua libre

E Hiponatremia hipovolémica por pérdidas extrarrenales; suero fisiológico 0,9 %

Respuesta E. Sodio urinario menor de 20 a 30 mEq/L en una paciente deshidratada indica que el riñón ahorra sodio: la pérdida es extrarrenal, aquí la diarrea. Se repone volumen con suero fisiológico. En el SIADH y en la pérdida renal el sodio urinario es alto.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 74 años con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, en control irregular, que suspendió sus diuréticos hace 1 mes. Consulta por disnea y aumento de volumen de piernas. Ingurgitación yugular, crépitos bibasales, edema hasta las rodillas. Na 127 mEq/L, K 4,4 mEq/L, creatinina 1,2 mg/dL. Sodio urinario 11 mEq/L. **¿Cuál es la interpretación más adecuada de la hiponatremia?**

A SIADH, por ser una hiponatremia con orina concentrada

B Hiponatremia hipovolémica por pérdidas digestivas

C Pérdida renal de sal por nefropatía

D Hiponatremia hipervolémica por bajo volumen circulante efectivo

E Seudohiponatremia por hiperlipidemia

Respuesta D. Edema con sodio urinario bajo: el riñón percibe hipoperfusión (volumen circulante efectivo bajo) y retiene sodio y agua por aldosterona y hormona antidiurética. Es la hiponatremia hipervolémica de la insuficiencia cardíaca o la cirrosis. Se maneja con restricción hídrica y diurético de asa, no con suero.

▶ VER CLASE 1.09.4.017 **Urocultivo y antibiograma** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.4 · Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Toma: segundo chorro con aseo previo en adultos y niños con control de esfínter; en lactantes sondeo vesical (≥10.000 UFC) o punción suprapúbica; la bolsa recolectora no confirma ITU.
- Positivo: ≥100.000 UFC/mL de un germen en segundo chorro; con varios gérmenes sospechar contaminación.
- Pedir antes del antibiótico en pielonefritis, embarazo, hombre, niños, ITU recurrente o complicada, sin retrasar el tratamiento empírico.
- No pedir de rutina ni de tamizaje (salvo embarazo): la bacteriuria asintomática no se trata fuera del embarazo o procedimientos urológicos.
- El antibiograma permite ajustar: E. coli resistente a cefalosporinas = BLEE (carbapenémico); en Chile hay alta resistencia a quinolonas y cotrimoxazol.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años, no embarazada, sin diabetes ni patología urológica, asintomática. En un chequeo de rutina se solicitó urocultivo, que informa más de 100.000 UFC/mL de E. coli sensible a nitrofurantoína. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Nitrofurantoína por 5 días

B Ciprofloxacino por 7 días

C No tratar: es una bacteriuria asintomática

D Repetir el urocultivo cada mes

E Ecografía renal y cistoscopía

Respuesta C. Bacteriuria asintomática en mujer no embarazada: no se trata, porque no reduce infecciones sintomáticas y genera resistencia. Se trata solo en embarazadas y antes de procedimientos urológicos con sangrado de mucosa. El urocultivo se pide ante síntomas, no como tamizaje general.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

7 códigos

▶ VER CLASE 1.09.5.001 **Cistoscopia** NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.12 · Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV

QUÉ HAY QUE SABER

- Cistoscopía: visualización directa de uretra y vejiga con biopsia; examen de elección ante sospecha de cáncer vesical.
- Indicaciones: hematuria macroscópica o microscópica isomórfica en mayor de 50 años, fumador (>10 paquetes-año), exposición a aminas aromáticas o irradiación pélvica; síntomas irritativos refractarios (carcinoma in situ).
- Hematuria macroscópica indolora con coágulos en fumador = cáncer de vejiga hasta demostrar lo contrario, aunque ceda sola o el TAC sea normal.

- Se complementa con uroTAC (tracto superior) y urocultivo; la citología no la reemplaza.
- Contraindicada con ITU activa o sospecha de lesión uretral traumática. El médico general deriva a urología y emplea el informe.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 66 años, fumador de 40 paquetes-año, presenta en 2 ocasiones hematuria macroscópica total, indolora, con coágulos. Urocultivo negativo y función renal normal. **¿Cuál es el examen fundamental para el diagnóstico?**

A Cistoscopía
B Citología urinaria como único examen
C Repetir orina completa en 3 meses
D Antígeno prostático específico
E Ecografía renal sin otro estudio

Respuesta A. La hematuria macroscópica indolora en un fumador mayor de 40 años es cáncer vesical hasta demostrar lo contrario. La cistoscopía visualiza directamente la vejiga y permite biopsiar; se complementa con uro-TAC para evaluar el tracto urinario alto. La citología tiene baja sensibilidad en tumores de bajo grado y no reemplaza la cistoscopía.

▶ VER CLASE 1.09.5.002 Cistostomía de urgencia

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.2 · Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Cistostomía suprapúbica por punción: drenaje vesical cuando no se puede o no se debe sondar por la uretra.
- Indicaciones: retención urinaria con sospecha de trauma uretral (uretrorragia, hematoma perineal en alas de mariposa, fractura de pelvis), sonda imposible por estenosis o falsa vía, prostatitis aguda grave.
- Requisito: globo vesical palpable (contraindicada sin globo); idealmente guiada por ecografía.
- Técnica: asepsia, anestesia local, punción en línea media 2 cm sobre el pubis con trocar de 10–14 Fr (Cystofix), confirmar orina y fijar; descompresión continua.
- Complicaciones: punción intestinal, hematoma de pared, hematuria. Luego estudiar la uretra con uretrografía retrógrada y derivar a urología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años, motociclista, con fractura de pelvis tras una colisión. Presenta sangre en el meato uretral, hematoma perineal y globo vesical palpable, y no puede orinar. **¿Cuál es la conducta más adecuada para drenar la vejiga?**

A Instalar sonda Foley forzando el paso
B Nefrostomía percutánea bilateral
C Esperar la micción espontánea
D Sonda Foley de menor calibre bien lubricada
E Cistostomía suprapúbica

Respuesta E. Sangre en el meato con fractura de pelvis sugiere lesión de la uretra posterior: está contraindicado instalar una sonda uretral, que puede completar la rotura. Se estudia con uretrografía retrógrada y la vejiga se drena con cistostomía suprapúbica, idealmente guiada por ecografía. La nefrostomía corresponde a obstrucción alta, no vesical.

▶ VER CLASE 1.09.5.003 Instalación pigtail

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.1 · Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Catéter ureteral doble J (pigtail): drenaje interno de la vía urinaria alta, instalado por urología vía cistoscópica.
- Indicaciones urgentes: cálculo obstructivo con fiebre o sepsis (pionefrosis), monorreno obstruido, anuria o falla renal postrenal, dolor refractario.
- En la pielonefritis obstructiva: antibióticos, volumen y descompresión inmediata; el tratamiento del cálculo (LEOC o ureteroscopía) se difiere hasta resolver la infección.
- Si no es posible pasarlo (meatos infiltrados por tumor, uréter infranqueable): nefrostomía percutánea.
- Complicaciones: síntomas irritativos, hematuria, ITU, migración e incrustación; debe retirarse o cambiarse en plazo. El médico general reconoce la indicación y deriva.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años con un cálculo de 8 mm en el uréter proximal izquierdo e hidronefrosis moderada presenta fiebre de 39 °C, escalofríos, PA 95/60 mmHg y leucocitosis. **Además de antibióticos y fluidos, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Litotripsia extracorpórea urgente

B Nefrectomía de urgencia

C Tamsulosina y esperar la expulsión

D Drenaje urgente de la vía urinaria con catéter ureteral doble J (pigtail) o nefrostomía

E Ureteroscopía con litotricia láser inmediata

Respuesta D. La pielonefritis obstructiva es una emergencia urológica: además de antibióticos, requiere descompresión urgente con catéter doble J (pigtail) por vía cistoscópica o con nefrostomía percutánea. El tratamiento definitivo del cálculo se difiere hasta resolver la infección, porque la litotripsia o la ureteroscopía en este contexto aumentan el riesgo de sepsis.

▶ VER CLASE 1.09.5.004 Instalación y cuidado de sonda Foley

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 2.3 · IAAS, Infecciones de Catéteres Vasculares y Precauciones de Aislamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: retención urinaria aguda sin trauma uretral, diuresis horaria en paciente inestable, obstrucción baja con IRA; no para comodidad de enfermería.
- Técnica: aséptica, sonda 16–18 Fr, lidocaína jalea 2%; avanzar sin forzar hasta la bifurcación y confirmar salida de orina antes de inflar el balón con agua destilada.
- Contraindicada si hay uretrorragia, hematoma perineal o fractura de pelvis (cistostomía); no insistir si hay resistencia o sangrado.
- Descompresión continua y completa (el clampeo intermitente está obsoleto); si drena >1.000 mL vigilar diuresis postobstructiva y potasio.
- Cuidados: sistema cerrado, bolsa bajo el nivel vesical, reponer el prepucio (evita parafimosis) y retirar lo antes posible; no profilaxis antibiótica ni urocultivo de rutina.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 74 años hospitalizado por neumonía tiene una sonda Foley instalada desde su ingreso a urgencia hace 5 días para control de diuresis. Actualmente está estable, deambula y puede orinar con ayuda. **¿Cuál es la medida más eficaz para prevenir la infección urinaria asociada a catéter?**

A Cambiar la sonda cada 3 días

B Desconectar la bolsa recolectora cada vez que se vacía

C Irrigación vesical diaria con suero

D Profilaxis antibiótica mientras tenga sonda

E Retirar la sonda lo antes posible, ya que no tiene indicación vigente

Respuesta E. El principal factor de riesgo de infección urinaria asociada a catéter es la duración del cateterismo. Lo más eficaz es instalar la sonda solo con indicación precisa y retirarla apenas deja de ser necesaria, usando técnica aséptica, sistema cerrado y bolsa bajo el nivel de la vejiga. No se recomiendan irrigación, profilaxis ni cambios programados.

▶ VER CLASE 1.09.5.005 Nefrostomia percutánea

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.2 · Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Nefrostomía percutánea: drenaje externo de la pelvis renal por punción lumbar guiada por imagen (radiología intervencional o urología).
- Indicaciones: obstrucción ureteral cuando no se puede pasar un doble J (tumor pélvico que infiltra el trígono, cáncer cervicouterino avanzado), pionefrosis en paciente inestable.
- Permite además acceso para nefrolitotomía percutánea y estudios anterógrados.
- Complicaciones: hematuria, sangrado perirrenal, desplazamiento del catéter, infección, fístula.
- El médico general reconoce la obstrucción alta (hidroureteronefrosis en ecografía con falla renal) y deriva de urgencia; la sonda Foley y la cistostomía no resuelven una obstrucción ureteral.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 52 años con cáncer cervicouterino avanzado presenta oliguria y creatinina de 5,2 mg/dL. La ecografía muestra hidroureteronefrosis bilateral por compresión tumoral de ambos uréteres distales, y la cistoscopía muestra infiltración tumoral del trígono que impide identificar los meatos ureterales. **¿Cuál es la conducta más adecuada para descomprimir la vía urinaria?**

A Sonda Foley

B Nefrostomía percutánea

C Catéter doble J por vía cistoscópica

D Cistostomía suprapúbica

E Hemodiálisis como único tratamiento

Respuesta B. En la obstrucción ureteral bilateral, cuando no es posible pasar un catéter doble J por vía retrógrada porque los meatos están infiltrados por tumor, se realiza una nefrostomía percutánea guiada por imágenes, que drena directamente la pelvis renal. La sonda Foley y la cistostomía drenan solo la vejiga y no resuelven una obstrucción ureteral.

▶ VER CLASE 1.09.5.006 Tacto ginecológico para masas u alteraciones obstructivas

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.4 · Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Tacto vaginal bimanual: una mano en vagina y otra en abdomen para evaluar tamaño, forma, consistencia y movilidad del útero y anexos.
- Técnica: consentimiento, vejiga vacía, posición ginecológica, guantes y lubricante; identificar cuello, fondo uterino y anexos, y el fondo de saco de Douglas.
- Útero aumentado, irregular y firme con sangrado abundante sugiere miomatosis; los miomas grandes, cervicales o de cara posterior pueden comprimir vejiga o uretra y causar retención.
- Masa anexial, nodularidad del Douglas (endometriosis) o tumor pélvico fijo pueden comprimir uréteres (hidronefrosis); en cáncer cervicouterino avanzado evaluar parametrios.
- Confirmar con ecografía transvaginal, medir residuo y descartar hidronefrosis; derivar a ginecología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 46 años consulta por dificultad para orinar, sensación de vaciado incompleto y pesadez pélvica de meses, con menstruaciones abundantes. Al tacto vaginal bimanual se palpa un útero aumentado de tamaño, irregular y de consistencia firme, que ocupa la pelvis y desplaza el cuello hacia anterior. **¿Cuál es la causa más probable de sus síntomas urinarios?**

A Compresión vesical o uretral por miomatosis uterina

B Vejiga neurogénica

C Cistitis intersticial

D Incontinencia urinaria de esfuerzo

E Litiasis vesical

Respuesta A. El tacto ginecológico bimanual permite detectar masas pélvicas que comprimen la vía urinaria. Un útero aumentado, irregular y firme con sangrado abundante sugiere miomatosis; los miomas grandes, cervicales o de cara posterior pueden comprimir la vejiga o la uretra y causar retención. Se confirma con ecografía transvaginal y se evalúan el residuo y la hidronefrosis.

▶ VER CLASE 1.09.5.007 Tacto rectal para reconocimiento básico de crecimiento prostático

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.3 · Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP

QUÉ HAY QUE SABER

- Tacto rectal: paciente en decúbito lateral o genupectoral, explicar el procedimiento, guante y lubricante; evaluar tamaño, consistencia, superficie, surco medio, sensibilidad y movilidad.
- HPB: próstata aumentada, simétrica, lisa, consistencia elástica (como la eminencia tenar), bordes netos y surco medio borrado; el tamaño no se correlaciona con los síntomas.
- Nódulo pétreo, irregular, asimétrico o fijo sugiere cáncer de próstata y obliga a derivar para biopsia aunque el APE sea normal.
- Próstata muy dolorosa, caliente o fluctuante: prostatitis aguda o absceso; no masajear.
- Se complementa con APE, creatinina, sedimento e IPSS; el tamaño estimado >40 cc orienta a inhibidor de 5-alfa reductasa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años con nicturia y chorro débil. Se realiza tacto rectal para evaluar la próstata. **¿Cuál de los siguientes hallazgos es característico de la hiperplasia prostática benigna?**

A Próstata aumentada de tamaño, de superficie lisa, consistencia elástica y surco medio borrado

B Nódulo pétreo e irregular en un lóbulo

C Próstata muy dolorosa, caliente y fluctuante

D Próstata fija a planos profundos

E Próstata de tamaño normal con induración difusa

Respuesta A. En la hiperplasia prostática benigna el tacto muestra una próstata aumentada de volumen, simétrica y lisa, de consistencia elástica (similar a la eminencia tenar) y con surco medio borrado. Un nódulo pétreo, irregular o fijo sugiere cáncer y obliga a biopsia aun con APE normal. Una próstata muy dolorosa sugiere prostatitis aguda, en la que no se debe masajear.

10 NEUROLOGÍA

62 CÓDIGOS

140 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	29
Situaciones clínicas de urgencia	21
Conocimientos generales	2
Exámenes e imagenología	7
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	3

Situaciones clínicas

29 códigos

▶ VER CLASE **1.10.1.001** **Cefalea tensional** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.6 · Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

QUÉ HAY QUE SABER

- Cefalea tensional: la cefalea primaria más frecuente; opresiva «como un casco», bilateral (holocránea u occipitofrontal), leve a moderada, de 30 minutos a 7 días.
- No empeora con la actividad, nunca da náuseas ni vómitos y puede tener fotofobia o fonofobia, pero no ambas (diferencia con la migraña).
- Diagnóstico clínico con examen neurológico normal: sin banderas rojas (SNOOP10) no requiere TAC.
- Crisis: paracetamol o AINE (ibuprofeno 400–800 mg, naproxeno 500–550 mg); limitar analgésicos a <15 días/mes para evitar cefalea por abuso de medicación.
- Crónica (≥15 días/mes): profilaxis con amitriptilina 10–50 mg en la noche, manejo del estrés, ejercicio e higiene del sueño.
- Seguimiento completo en APS: registrar frecuencia y consumo de analgésicos; reevaluar ante cambio de patrón o bandera roja.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 59

Un paciente de 40 años consulta por cefalea holocránea, mayor en la zona occipital, que se irradia al cuello. Suele iniciarse a medio día y alcanza su máxima intensidad al llegar a su casa, después del trabajo. Su examen neurológico no tiene signos focales ni meníngeos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Cefalea tensional
B Migraña
C Cefalea en racimo o cluster
D Cefalea por hipertensión endocraneana
E Neuralgia de Arnold

Respuesta A. Cefalea holocránea, occipital, que se irradia al cuello y aumenta a lo largo de la jornada, sin náuseas ni signos focales: cefalea tensional clásica. La migraña es unilateral y pulsátil con náuseas o foto y fonofobia; la hipertensión endocraneana predomina en la mañana.

▶ VER CLASE **1.10.1.002** **Compromiso de conciencia** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.12 · Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

QUÉ HAY QUE SABER

- Cuantificar con Glasgow (ocular 4, verbal 5, motor 6): ≤8 = compromiso grave, indicación de intubar para proteger la vía aérea (con protección cervical si hay trauma).
- ABC, glicemia capilar inmediata, signos vitales, pupilas y búsqueda de focalidad, signos meníngeos y signos de herniación (midriasis unilateral, tríada de Cushing).
- Separar causa estructural (focalidad, pupilas asimétricas: ACV, hematoma, tumor) de tóxico-metabólica (pupilas reactivas, sin focalidad: hipoglicemia, hiponatremia, uremia, encefalopatía hepática, intoxicación, sepsis).
- Medidas iniciales: glucosa si hay hipoglicemia (tiamina antes en alcohólicos o desnutridos), naloxona si hay miosis y bradipnea, TAC de cerebro sin contraste.
- Fiebre con meningismo: hemocultivos, dexametasona y antibióticos antes de la imagen; herniación: cabecera a 30°, normoventilación y manitol o suero hipertónico.
- Seguimiento: derivar a UPC y al especialista según la causa (neurocirugía, neurología).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 35 años tras un accidente de tránsito: abre los ojos solo ante estímulo doloroso, emite sonidos incomprensibles y retira la extremidad ante el dolor. **¿Cuál es su puntaje en la escala de Glasgow y la conducta respecto de la vía aérea?**

A Glasgow 6; solo ventilación con mascarilla
B Glasgow 10; observar
C Glasgow 8; requiere intubación para proteger la vía aérea
D Glasgow 12; oxígeno por naricera
E Glasgow 9; cánula orofaríngea y alta

Respuesta C. Apertura ocular al dolor suma 2, sonidos incomprensibles 2 y retiro ante el dolor 4: Glasgow 8. Un Glasgow de 8 o menos define un compromiso de conciencia grave y es indicación de intubación para proteger la vía aérea, con protección de la columna cervical. Luego se realiza TAC de cerebro.

▶ VER CLASE **1.10.1.003**

Cuadros de deterioro orgánico cerebral potencialmente reversibles (hipotiroidismos, déficit de vitamina B12, etc.)

DX SOSPECHA · TX INICIAL · SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.14 · Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

QUÉ HAY QUE SABER

- Ante todo deterioro cognitivo buscar causas potencialmente reversibles antes de rotular una demencia degenerativa.
- Laboratorio obligatorio: TSH (hipotiroidismo: bradipsiquia), vitamina B12, VDRL o RPR (neurosífilis), hemograma, electrolitos, función renal y hepática, glicemia y calcio.
- Neuroimagen (TAC o RM sin contraste): hematoma subdural crónico, tumores (meningioma frontal) e hidrocefalia normotensiva (marcha magnética, incontinencia y demencia).
- Déficit de B12: degeneración combinada subaguda (cordones posteriores y laterales) con neuropatía; tratar con cianocobalamina 1.000 µg IM; revierte si lleva <6–12 meses. Nunca ácido fólico solo.
- Descartar también depresión (pseudodemencia), fármacos (anticolinérgicos, benzodiacepinas), alcohol y déficit de tiamina.
- Seguimiento: no requiere seguimiento especial si se corrige la causa; reevaluar la cognición tras el tratamiento.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 104

Hombre de 72 años con cefalea holocraneal progresiva de 3 meses de evolución, asociada a ataxia de la marcha y deterioro cognitivo leve. TAC de cerebro: colección hipodensa crónicamente organizada entre el córtex y el hueso craneal, sin efecto de masa severo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Tumor cerebral primario

B Metástasis cerebrales

C Hematoma subdural crónico

D Hidrocefalia normotensiva

E Enfermedad de Alzheimer

Respuesta C. Colección hipodensa crónica entre la corteza y el cráneo en un adulto mayor con cefalea, trastorno de la marcha y deterioro cognitivo: hematoma subdural crónico, causa estructural y tratable de deterioro cognitivo. Por eso la neuroimagen es obligatoria en el estudio.

▶ VER CLASE **1.10.1.004**

Cuadros deficitarios de funciones cerebrales superiores (afasia, apraxia, agnosia, etc)

DX SOSPECHA · TX INICIAL · SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.1 · Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Afasia de Broca (frontal inferior dominante): no fluente, con esfuerzo, comprensión relativamente conservada y conciencia del déficit.
- Afasia de Wernicke (temporal superior posterior dominante): fluente pero sin sentido, parafasias y neologismos, mala comprensión y repetición, anosognosia.
- Negligencia (parietal no dominante); apraxia ideomotora (no ejecuta gestos con fuerza conservada); agnosia visual y alexia sin agrafia (cerebral posterior).
- De inicio súbito orientan a ACV cortical de la cerebral media: código ACV, TAC sin contraste urgente y evaluar trombolisis.
- De instalación progresiva: tumor o demencia (afasia primaria progresiva de la demencia frontotemporal); estudiar con neuroimagen.
- Seguimiento: derivar a neurología y rehabilitación (fonoaudiología, terapia ocupacional).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 70 años presenta en forma súbita un habla fluente pero sin sentido, con parafasias y neologismos. No comprende órdenes simples, no logra repetir frases y no parece darse cuenta de su déficit. No tiene paresia. **¿Cuál es la localización más probable de la lesión?**

A Circunvolución frontal inferior izquierda (área de Broca)

B Lóbulo parietal derecho

C Porción posterior de la circunvolución temporal superior izquierda (área de Wernicke)

D Cerebelo

E Tronco encefálico

Respuesta C. Una afasia fluente con mala comprensión, mala repetición, parafasias y anosognosia es una afasia de Wernicke, por lesión de la porción posterior del giro temporal superior del hemisferio dominante, típicamente por un ACV de la división inferior de la arteria cerebral media izquierda. La afasia de Broca es no fluente, con comprensión relativamente conservada.

▶ VER CLASE **1.10.1.005**

Demencia (Enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, VIH, etc)

DX SOSPECHA · TX INICIAL · SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.14 · Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve
Neurología 10.15 · Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal

QUÉ HAY QUE SABER

- Demencia: deterioro cognitivo con pérdida de autonomía en actividades instrumentales (Pfeffer ≥6); DCL si el test está alterado pero conserva autonomía.
- Tamizaje: MMSE (<24, ajustado por escolaridad; en EMPAM, Minimental abreviado <13 + Pfeffer), MoCA (<26, más sensible para DCL) y test del reloj.
- Alzheimer: amnesia anterógrada insidiosa, anosognosia. Vascular: escalones y signos focales. Lewy: fluctuaciones, alucinaciones visuales y parkinsonismo. Frontotemporal: <65 años, desinhibición con memoria conservada.
- Estudio de causas reversibles en todos: TSH, B12, VDRL, perfil bioquímico y TAC o RM; en VIH avanzado considerar demencia asociada al VIH.
- Tratamiento inicial: Alzheimer leve-moderado donepezilo 5→10 mg con ECG basal (GES); memantina si MMSE <15; Lewy donepezilo y nunca haloperidol; vascular con control de riesgo vascular y aspirina.
- Seguimiento: derivar para confirmación y manejo especializado; apoyo al cuidador (Zarit). Agitación: medidas no farmacológicas, luego quetiapina en dosis baja; evitar benzodiacepinas.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 129

Paciente con 1 año de alucinaciones visuales, pérdida de memoria progresiva, rigidez, hipocinesia y alteración de la marcha. **¿Diagnóstico más probable?**

A Enfermedad de Parkinson con demencia
B Enfermedad de Alzheimer
C Demencia frontotemporal
D Demencia por cuerpos de Lewy
E Parálisis supranuclear progresiva

Respuesta D. Alucinaciones visuales, deterioro cognitivo y parkinsonismo que aparecen juntos, dentro del mismo año: demencia por cuerpos de Lewy. En la demencia de la enfermedad de Parkinson, el parkinsonismo precede a la demencia por más de un año.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 35

Un paciente de 82 años, hace 2 años sufrió un accedente vascular encefálico, sin secuelas. Hace 2 meses presenta un cuadro de labilidad emocional, desinhibición social y dificultades para realizar algunas de sus actividades habituales. **El diagnóstico más probable es:**

A Depresión
B Enfermedad de Alzheimer
C Demencia vascular
D Demencia por cuerpos de Lewy
E Hidrocéfalo normotensivo

Respuesta C. El antecedente de ACV en un adulto mayor que luego pierde funcionalidad orienta a demencia vascular; la labilidad emocional y la desinhibición sugieren compromiso subcortical y frontal. A los 82 años, la desinhibición no hace pensar en frontotemporal, que es presenil.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 85

Un paciente de 55 años ha presentado varios cambios congnitivos conductuales, como tendencia a la apatía, lenguaje coprolálico o andar desnudo. No ha tenido alteraciones en la conciencia ni en la memoria. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Demencia por cuerpos de Lewy
B Hidrocefalia normotensiva
C Enfermedad de Alzheimer
D Demencia frontotemporal
E Delirium

Respuesta D. Menor de 65 años, apatía y desinhibición (coprolalia, andar desnudo) con memoria conservada: variante conductual de la demencia frontotemporal. Sin compromiso de conciencia, no es delirium.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 71 años, profesor jubilado, traído por su hija por 16 meses de olvidos progresivos: repite las mismas preguntas, olvida citas y dejó la estufa encendida dos veces. Hace un mes se desorientó manejando al supermercado. Él minimiza el problema. Lúcido, atención normal. MMSE 21/30 (falla en memoria diferida y orientación), test del reloj muy alterado, Pfeffer 8 (dependiente para finanzas y electrodomésticos). Examen neurológico sin focalidad. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tranquilizar: son olvidos propios de la edad; control en un año
B Diagnosticar deterioro cognitivo leve y control semestral sin fármacos
C Solicitar TSH, B12, VDRL, perfil bioquímico y TAC cerebral, e iniciar donepezilo 5 mg/día
D Iniciar memantina 20 mg/día como monoterapia
E Iniciar lorazepam nocturno

Respuesta C. Deterioro amnésico anterógrado progresivo de más de un año, reloj alterado y Pfeffer 8 (pérdida de autonomía): demencia tipo Alzheimer leve a moderada, no DCL. Según GES: descartar causas reversibles (TSH, B12, VDRL, bioquímico), neuroimagen sin contraste e iniciar un IAChE (donepezilo 5 mg/día), más apoyo al cuidador. Memantina es para MMSE < 15; las benzodiacepinas están contraindicadas.

▶ VER CLASE **1.10.1.006** **Enfermedad de Parkinson y parkinsonismos** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.11 · Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras
Neurología 10.12 · Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus

QUÉ HAY QUE SABER

- Parkinsonismo: bradicinesia (golpeteo de dedos que decrece) obligatoria + temblor de reposo 4–6 Hz o rigidez en rueda dentada; asimétrico al inicio. Diagnóstico clínico.
- Pródromos: hiposmia, constipación, trastorno conductual del sueño REM y depresión; inestabilidad postural es tardía.
- Excluir parkinsonismo por fármacos (metoclopramida, antipsicóticos, flunarizina, cinarizina): simétrico y subagudo; se suspende el fármaco sin dar levodopa.
- Banderas rojas de Parkinson-plus: caídas precoces y mirada vertical hacia abajo (PSP), disautonomía grave precoz (AMS), apraxia y mano ajena (corticobasal), marcha a pasos cortos con braceo normal (vascular).
- Tratamiento inicial: ≥65 años levodopa/carbidopa 100/25 mg c/8 h lejos de las proteínas; jóvenes agonista (pramipexol) o IMAO-B, vigilando control de impulsos.
- GES: confirma el neurólogo; con los años wearing-off (fraccionar, entacapona) y disquinesias (amantadina).

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 22

Un hombre de 55 años, diabético de larga data, presenta temblor de reposo y lentitud al realizar actividades, como vestirse, lo que se ha asociado a dificultades para iniciar la marcha. Relata que se había caído hacia adelante, en dos oportunidades, al empezar a caminar. Al inicio de la marcha es lento e inseguro, pero luego alcanza una velocidad normal, la que se mantiene por el resto del tiempo. No presenta disminución de las fuerzas de las extremidades y sus reflejos osteotendíneos son normales, al igual que la sensibilidad. **El diagnóstico más probable es:**

A Enfermedad de Parkinson
B Enfermedad de Alzheimer
C Polineuropatía diabética
D Polimialgia reumática
E Miopatía por cuerpos de inclusión

Respuesta A. Temblor de reposo + bradicinesia (lentitud para vestirse) + dificultad para iniciar la marcha: enfermedad de Parkinson. Fuerza, reflejos y sensibilidad normales descartan la polineuropatía diabética y las miopatías.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 99

Un paciente de 62 años, con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento con doxazosina, hiperplasia prostática benigna en tratamiento con tamsulosina y trastorno afectivo bipolar en tratamiento con carbonato de litio, consulta por temblor de manos mayor a derecha que aparece con el reposo y se asocia a lentitud en los movimientos. El cuadro inició hace 4 meses. Se miden los niveles plasmáticos de los fármacos que utiliza, los que son informados dentro de rango terapéutico. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Suspender la doxazosina
B Disminuir la dosis de carbonato de litio
C Suspender la tamsulosina
D Realizar prueba con levodopa
E Iniciar propranolol vía oral

Respuesta D. Temblor de reposo asimétrico + bradicinesia: enfermedad de Parkinson, de diagnóstico clínico; la respuesta a levodopa apoya el diagnóstico. El litio puede dar temblor, pero los niveles están en rango. El propranolol es para el temblor esencial.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 26

Un paciente de 70 años presenta un cuadro de dificultad para girarse y para meterse a la tina, asociado a múltiples caídas. Además presenta cambios en la escritura y temblor de reposo. No presenta deterioro cognitivo evidente. **El diagnóstico más probable es:**

A Atrofia generalizada
B Hidrocefalia normotensiva
C Temblor senil
D Demencia por cuerpos de Lewy
E Enfermedad de Parkinson

Respuesta E. Bradicinesia (dificultad para girarse), micrografía y temblor de reposo: enfermedad de Parkinson. Sin deterioro cognitivo no calza la demencia por cuerpos de Lewy ni la hidrocefalia normotensiva, y el temblor de reposo no es un temblor "senil".

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años con 14 meses de temblor de la mano derecha que aparece con el brazo apoyado y cede al tomar una taza. Camina más lento y perdió expresividad facial. Examen: hipomimia, hipofonía, braceo derecho disminuido, pasos cortos, rigidez en rueda dentada en muñeca y codo derechos, temblor de reposo de 5 Hz y golpeteo de dedos lento y decreciente a derecha. Sin caídas, sin alteración oculomotora ni disautonomía. **¿Cuál es la conducta farmacológica más adecuada?**

A Propranolol 40 mg cada 12 horas

B Pramipexol como monoterapia para postergar la levodopa

C Levodopa/carbidopa 100/25 mg cada 8 horas, lejos de las comidas proteicas

D Diferir el tratamiento hasta que aparezca inestabilidad postural

E Amantadina 100 mg cada 12 horas

Respuesta C. Parkinson idiopático con criterios MDS: bradicinesia (finger tapping decreciente) + temblor de reposo + rigidez, asimétrico y sin banderas rojas. En mayores de 65 años se inicia levodopa/carbidopa, alejada de las comidas proteicas. Los agonistas se reservan para menores de 65; la amantadina es para disquinesias; el propranolol es para el temblor esencial.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 40

Paciente en tratamiento anti hipertensivo + sd vertiginoso en tto con Cinarizina, metformina, inicia temblor de reposo, simétrico, bilateral, rigidez y asociado a caídas frecuentes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Parkinson POR QUÉ NO PODÍA SER PÁRKINSON ? Porque describía un temblor bilateral simétrico, Parkinson inicia como unilateral y no simétrico

B Parkinsonismo por fármacos

C Accidente cerebrovascular

D Epilepsia

E Esclerosis múltiple

Respuesta A. Diagnóstico: Parkinson POR QUÉ NO PODÍA SER PÁRKINSON ? Porque describía un temblor bilateral simétrico, Parkinson inicia como unilateral y no simétrico (opción A).

▶ VER CLASE 1.10.1.007 Epilepsia

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.8 · Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES
Neurología 10.10 · Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Epilepsia (ILAE): 2 crisis no provocadas separadas >24 h, o 1 con riesgo de recurrencia >60% (lesión en imagen o EEG epileptiforme).
- Clasificar el inicio: focal (con o sin alteración de conciencia, automatismos, evolución a bilateral) o generalizado (tónico-clónica, ausencias con punta-onda 3 Hz, mioclonías de la EMJ).
- Estudio: EEG (normal en la mitad; repetir con privación de sueño) y RM con protocolo de epilepsia; TAC solo en urgencia.
- Fármaco según crisis y paciente: focal lamotrigina, levetiracetam o carbamazepina; generalizada valproato en hombres; mujer fértil lamotrigina o levetiracetam + ácido fólico 5 mg; adulto mayor levetiracetam.
- Toxicidades: valproato teratógeno; carbamazepina hiponatremia y Stevens-Johnson; fenitoína hiperplasia gingival; levetiracetam irritabilidad. Carbamazepina y fenitoína agravan ausencias y mioclonías.
- GES en ≥15 años: especialista y EEG en 30 días; no conducir. Derivar a centro de epilepsia si fallan 2 fármacos bien usados (refractaria).

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 143

Paciente con mirada forzada hacia la derecha, luego espasmo hemifacial, luego movimientos de sacudidas en las 4 extremidades. **¿Diagnóstico más probable?**

A Crisis focal con generalización secundaria

B Crisis tónico-clónica generalizada primaria

C Estatus epiléptico no convulsivo

D Accidente isquémico transitorio (AIT)

E Crisis mioclónica juvenil

Respuesta A. La crisis parte con signos focales (desviación forzada de la mirada, espasmo de una hemicara) y luego compromete las 4 extremidades: crisis focal con evolución a tónico-clónica bilateral (antigua secundariamente generalizada). El signo inicial define el inicio focal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 133

Una paciente de 14 años sufre una convulsión tónico clónica, luego de una noche con privación de sueño y exposición a pantallas. Previo a esto, presentaba movimientos bruscos, como sacudidos, de manera involuntaria. Sus amigas relatan que en ocasiones "se queda pegada" por algunos segundos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Epilepsia mioclónica juvenil
B Epilepsia de ausencia juvenil
C Epilepsia tónicoclónica
D Epilepsia focal
E Crisis convulsiva por privación de sueño

Respuesta A. Adolescente con mioclonías, ausencias ocasionales y una convulsión tónico-clónica gatillada por privación de sueño: epilepsia mioclónica juvenil, que combina los tres tipos de crisis generalizadas. La privación de sueño es el gatillante, no el diagnóstico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 41

Un niño de 16 años convulsiona al despertar, en la mañana siguiente de haber estado jugando videojuegos hasta tarde. Además, refiere mioclonías matinales frecuentes, desde hace algunos meses. Su examen físico es normal, al igual que su examen neurológico. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A Suspender por completo los videojuegos
B Ácido valproico
C Carbamazepina
D Melatonina en la noche
E Diazepam si convulsiona nuevamente

Respuesta B. Epilepsia mioclónica juvenil en un hombre: el fármaco más efectivo es el ácido valproico. La carbamazepina agrava las mioclonías y las ausencias. En una mujer en edad fértil se preferiría lamotrigina o levetiracetam.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 140

Niño o adolescente con conducta disruptiva + crisis de ausencia. **¿Como estudiarlo?**

A Electroencefalograma
B TAC
C RNM
D Psicometria
E Control sano habitual

Respuesta A. Ante la sospecha de crisis de ausencia, el examen de elección es el electroencefalograma, que muestra la punta-onda generalizada a 3 Hz, patognomónica. La neuroimagen no es el estudio inicial de una epilepsia generalizada, y la psicometría confunde las ausencias con un problema de conducta o atención.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 41

Adolescente de 16 años convulsiona al despertar, en la mañana siguiente de haber estado jugando videojuegos hasta tarde. Además refiere mioclonías matinales frecuentes desde hace algunos meses. Su examen físico es normal, al igual que su examen neurológico. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A Suspender por completo los videojuegos
B Ácido valproico
C Carbamazepina
D Melatonina en la noche
E Diazepam si convulsiona nuevamente

Respuesta B. Mioclonías matinales más una crisis tónico-clónica al despertar tras privación de sueño: epilepsia mioclónica juvenil, una epilepsia generalizada que requiere tratamiento prolongado. El ácido valproico es de elección en varones (en mujeres en edad fértil se prefiere levetiracetam o lamotrigina). La carbamazepina agrava mioclonías y ausencias; evitar trasnochar ayuda, pero no reemplaza el fármaco.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 26 años, recién casada, desea embarazarse a corto plazo. Tiene epilepsia generalizada idiopática diagnosticada a los 16 años, sin crisis hace 3 años con ácido valproico 500 mg cada 12 horas. Examen neurológico normal; hemograma y pruebas hepáticas normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener el ácido valproico y agregar ácido fólico 1 mg al día
B Suspender de inmediato el ácido valproico
C Cambiar gradualmente a lamotrigina o levetiracetam e indicar ácido fólico 5 mg al día desde 3 meses antes de concebir
D Cambiar a carbamazepina, por su menor teratogenicidad
E Contraindicar el embarazo

Respuesta C. El valproato es el antiepiléptico más teratogénico (tubo neural 1–2 %, cardiopatías, autismo, bajo CI) y está contraindicado en la mujer en edad fértil. Se rota de forma programada y gradual a lamotrigina o levetiracetam, con ácido fólico 5 mg/día desde 3 meses antes de la concepción. Suspender bruscamente expone a crisis; la carbamazepina agrava las epilepsias generalizadas.

▶ VER CLASE **1.10.1.008** **Esclerosis múltiple** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.18 · Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad
Oftalmología 15.18 · Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

QUÉ HAY QUE SABER

- Mujer de 20–45 años con déficits focales separados en tiempo y espacio: neuritis óptica (baja visual con dolor al mover el ojo, discromatopsia, DPAR), mielitis parcial u oftalmoplejía internuclear.
- Signos: Uhthoff (empeora con calor, no es brote) y Lhermitte (descarga al flectar el cuello).
- Diagnóstico (McDonald 2017): RM con lesiones periventriculares, yuxtacorticales, infratentoriales o medulares (diseminación en espacio) y lesiones que captan y no captan (tiempo); bandas oligoclonales en LCR sustituyen la diseminación en tiempo.
- Brote (déficit nuevo >24 h sin fiebre): metilprednisolona 1 g/día EV por 3–5 días, sin descenso oral; plasmaféresis si no responde.
- Diferencial clave: neuromielitis óptica (neuritis bilateral grave, mielitis ≥3 vértebras, anti-acuaporina 4), que empeora con interferón y natalizumab.
- Seguimiento: no lo hace el médico general; derivar a neurología para terapia modificadora (GES).

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 104

Una paciente de 30 años presenta un cuadro de un mes de evolución de neuralgia de la primera rama del trigémino. Hace una semana se agrega disminución de la sensibilidad del muslo derecho, con dificultades para caminar. Como antecedente, refiere que hace un año tuvo un trastorno del equilibrio, que resolvió espontáneamente. **El diagnóstico más probable es:**

A Polineuropatía por déficit de vitamina B12
B Síndrome de Guillain Barré de presentación atípica
C Infarto talámico
D Esclerosis múltiple
E Neurinoma con compresión del troncoencéfalo

Respuesta D. Mujer joven con neuralgia de la primera rama (atípica, sugiere causa secundaria), más un déficit sensitivo nuevo y un episodio previo de desequilibrio que remitió: lesiones en distintos sitios y momentos. Es una esclerosis múltiple, causa clásica de neuralgia del trigémino secundaria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 17

Una paciente de 14 años presenta disminución de la visión del izquierdo, de dos días de evolución. Su agudeza visual es 20/200 en el ojo izquierdo y 20/20 en el derecho. Tiene antecedente de hemiparesia braquial. Al fondo de ojo se observa papilitis izquierda. Su resonancia magnética nuclear muestra lesiones desmielinizantes cerebrales. **El diagnóstico más probable es:**

A Desprendimiento de retina
B Neuritis óptica
C Neuropatía óptica isquémica
D Degeneración macular
E Hipertensión endocraneana

Respuesta B. Baja visual monocular en días, antecedente de otro déficit focal y lesiones desmielinizantes en la RM: neuritis óptica en el contexto de esclerosis múltiple. Un tercio de las neuritis muestra edema de papila (papilitis), que es unilateral; el edema de papila bilateral orienta a hipertensión endocraneana.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 104

Una paciente de 30 años presenta un cuadro de 1 mes de evolución de neuralgia de la primera rama del trigémino. Hace 1 semana se agrega disminución de la sensibilidad del muslo derecho, con dificultades para caminar. Como antecedente, refiere que hace 1 año tuvo un trastorno del equilibrio, que resolvió espontáneamente. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Polineuropatía por déficit de vitamina B12
B Síndrome de Guillain-Barré de presentación atípica
C Infarto talámico
D Esclerosis múltiple
E Neurinoma con compresión del troncoencéfalo

Respuesta D. Mujer joven con múltiples déficits focales separados en el espacio (trigémino, sensibilidad de extremidad, equilibrio) y en el tiempo, de inicio subagudo y con recuperación espontánea: es la definición clínica de esclerosis múltiple. Se estudia con resonancia magnética con gadolinio.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 26 años, profesora, con 3 días de baja visual del ojo derecho y dolor retroorbitario que empeora al mover los ojos; ve los rojos "deslavados". Hace un año tuvo parestesias en la pierna izquierda por 2 semanas, que cedieron solas. AV OD 20/100, OI 20/20; DPAR derecho; fondo de ojo normal. RM: lesiones periventriculares perpendiculares a los ventrículos y una yuxtacortical; dos captan gadolinio. LCR: 4 bandas oligoclonales IgG ausentes en suero. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Prednisona oral 1 mg/kg/día con descenso gradual

B Metilprednisolona EV 1 g/día por 3 a 5 días y derivar a neurología (GES)

C Natalizumab EV como primera medida

D Observar y repetir la RM en 6 meses para confirmar diseminación en tiempo

E Plasmaféresis de inmediato

Respuesta B. Neuritis óptica retrobulbar en una mujer joven con RM que cumple diseminación en espacio y en tiempo (lesiones que captan y no captan), además de bandas oligoclonales: esclerosis múltiple remitente-recurrente. El brote se trata con metilprednisolona EV 1 g/día por 3–5 días y se deriva para inicio de terapia modificadora GES. No hay que esperar otra RM; la plasmaféresis es rescate si falla el corticoide.

▶ VER CLASE 1.10.1.009 Herpes zoster

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.8 · Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Síndrome de Ramsay Hunt

QUÉ HAY QUE SABER

- Herpes zóster: reactivación del virus varicela-zóster en un ganglio sensitivo; dolor urente o pródromo de parestesias seguido de vesículas agrupadas en un dermatoma, unilateral, que no cruza la línea media.
- Más frecuente en mayores de 50 años e inmunosuprimidos; diagnóstico clínico.
- Tratamiento antiviral idealmente en las primeras 72 h: valaciclovir 1 g c/8 h o aciclovir 800 mg 5 veces al día por 7 días; analgesia según dolor.
- Formas especiales: oftálmico (V1; vesícula en la punta de la nariz = signo de Hutchinson, derivar a oftalmología) y Ramsay Hunt (parálisis facial + otalgia + vesículas en concha: valaciclovir 7–10 días + prednisona).
- Neuralgia postherpética (dolor >3 meses): pregabalina o gabapentina, amitriptilina, lidocaína tópica.
- Seguimiento completo: control de dolor y lesiones; en inmunosuprimidos o diseminado, hospitalizar con aciclovir EV y aislamiento.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 5

Una mujer de 64 años consulta por dolor intercostal intenso de 3 semanas de evolución, que fue antecedido por la aparición de lesiones vesiculares en esa zona. En el examen físico se observa curación de las lesiones, algunas de las cuales dejaron cicatrices, sin otras alteraciones. **¿Cuál es el tratamiento de elección para el manejo del dolor?**

A Pregabalina

B Galantamina

C Amitriptilina

D Carbamazepina

E Fluoxetina

Respuesta A. Dolor persistente en un dermatomo tras un herpes zóster ya cicatrizado es una neuralgia postherpética. El tratamiento de primera línea es pregabalina o gabapentina; la amitriptilina y la carbamazepina, antes de primera línea, hoy son de segunda línea.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 60 años consulta en urgencia por desviación de la comisura bucal hacia la derecha y dificultad para pronunciar las palabras desde hace 2 horas. Al examen físico se aprecia incapacidad para elevar la comisura labial izquierda; sin embargo, el paciente arruga la frente de forma perfectamente simétrica y ocluye ambos ojos con fuerza normal sin lagoftalmos. **¿Cuál es la localización topográfica más probable de la lesión y la conducta inmediata?**

A Lesión del nervio facial periférico izquierdo en el foramen estilomastoideo; indicar prednisona oral ambulatoria

B Lesión corticonuclear o hemisférica cerebral derecha (parálisis facial central); activar código de sospecha de ACV y solicitar TAC de cerebro de urgencia

C Síndrome de Ramsay Hunt atípico; iniciar valaciclovir oral en altas dosis

D Parálisis de Bell de curso frustro; indicar reposo y control ambulatorio en una semana

E Otitis media aguda complicada con compresión del canal de Falopio; solicitar TAC de peñasco

Respuesta B. La frente está respetada y no hay lagoftalmos: es una parálisis facial central. Por la doble inervación corticonuclear de la frente, una lesión hemisférica unilateral la respeta. Requiere código ACV y TAC de cerebro urgente. Tratarla como Bell con corticoides ambulatorios es un error grave.

▶ VER CLASE 1.10.1.010 Lumbago mecánico

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.15 · Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- Lumbago mecánico: la gran mayoría de los dolores lumbares; empeora con el movimiento y mejora con el reposo, sin irradiación bajo la rodilla ni déficit neurológico.

- Descartar banderas rojas: fiebre (espondilodiscitis), cáncer o baja de peso, dolor súbito en adulto mayor u osteoporosis (fractura), anestesia en silla de montar o retención urinaria (cauda equina), dolor que mejora con ejercicio en joven (espondilitis anquilosante).
- Sin banderas rojas no requiere imágenes (ni radiografía ni RM).
- Tratamiento: AINE en ciclos cortos (o paracetamol), mantener la actividad, evitar reposo prolongado, calor local y kinesioterapia; relajante muscular por pocos días si hay contractura.
- Educación: buen pronóstico, la mayoría mejora en 4–6 semanas; fortalecimiento de musculatura axial y abdominal para prevenir recurrencias.
- Seguimiento completo en APS: reevaluar a las 4–6 semanas; si persiste o aparecen banderas rojas, estudiar con imágenes y derivar.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 38 años, trabajador de bodega, presenta dolor lumbar de 4 días tras levantar una caja, sin irradiación bajo la rodilla. No tiene fiebre, baja de peso, alteración de esfínteres ni déficit neurológico. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Resonancia magnética de columna lumbar

B Radiografía de columna lumbosacra y reposo absoluto por 2 semanas

C Derivación a neurocirugía

D Analgesia con AINE o paracetamol y mantener la actividad según tolerancia, sin imágenes

E Corticoides sistémicos en dosis altas

Respuesta D. El lumbago mecánico agudo sin signos de alarma evoluciona favorablemente en 4 a 6 semanas. No requiere imágenes y se maneja con analgesia, calor local, educación y mantenerse activo, porque el reposo en cama retrasa la recuperación. Las imágenes se indican ante banderas rojas o persistencia mayor de 6 semanas.

▶ VER CLASE 1.10.1.011 Lumbociáticas y cervicobraquialgias.

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.15 · Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- Lumbociática: dolor lumbar irradiado bajo la rodilla por compresión radicular (hernia L4-L5 o L5-S1); Lasègue positivo. Cervicobraquialgia: dolor cervical irradiado al brazo, Spurling positivo.
- Precisar la raíz: L5 debilidad de dorsiflexión del ortejo mayor; S1 aquiliano disminuido y debilidad de flexión plantar; C6–C7 en el brazo.
- Banderas rojas: déficit motor progresivo, cauda equina (anestesia en silla de montar, retención urinaria) = RM y derivación urgente.
- Sin déficit: manejo igual al lumbago (AINE, actividad, kinesioterapia), puede sumarse analgésico para dolor neuropático; la mayoría mejora en 6 semanas.
- RM solo si hay banderas rojas, déficit o falla del tratamiento a las 6 semanas.
- Seguimiento: derivar a traumatología o neurocirugía si hay déficit agudo o fracaso médico (indicaciones de cirugía de la hernia).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años con dolor lumbar irradiado por la cara posterior del muslo y la pierna hasta la planta y el borde lateral del pie. Al examen presenta Lasègue positivo a 40°, hipoestesia del borde lateral del pie, debilidad de la flexión plantar y reflejo aquiliano disminuido. **¿Cuál es la raíz más probablemente comprometida?**

A L3

B S1

C L5

D L4

E S3

Respuesta B. La radiculopatía S1, típicamente por hernia discal L5-S1, produce dolor hacia la planta y el borde lateral del pie, debilidad de la flexión plantar y reflejo aquiliano disminuido. L5 compromete el dorso del pie y la extensión del ortejo mayor, sin alterar los reflejos clásicos, y L4 se asocia a reflejo rotuliano disminuido.

▶ VER CLASE 1.10.1.012 Migraña

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.6 · Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

QUÉ HAY QUE SABER

- Migraña sin aura (IHS): ≥5 crisis de 4–72 h con 2 de 4 (unilateral, pulsátil, moderada-severa, empeora con actividad) + náuseas/vómitos o fotofobia y fonofobia.
- Migraña con aura: síntomas focales reversibles de 5–60 min (visuales en >90%, escotoma centellante; sensitivos de marcha cheiro-oral) seguidos de cefalea en <60 min.
- Diagnóstico clínico; buscar banderas rojas (SNOOP10) antes de rotular: si no hay, no se pide imagen.
- Crisis precoz: AINE en dosis plena + metoclopramida 10 mg; si es severa o falla, sumatriptán 50–100 mg VO o 6 mg SC. Triptán contraindicado en coronarios, ACV previo, HTA severa y migraña hemipléjica.
- Profilaxis si ≥3 crisis/mes o discapacidad: propranolol 40–160 mg (no en asma), amitriptilina, flunarizina o topiramato; valproato proscrito en mujer fértil.
- Seguimiento completo: diario de cefalea; analgésicos <15 días/mes y triptán <10 días/mes para evitar cefalea por abuso de medicación.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 28 años, abogada, sin antecedentes mórbidos. Hace 3 años presenta 4 a 5 crisis al mes de cefalea hemicránea derecha pulsátil, que empeora al caminar, con fotofobia, fonofobia y náuseas, de 24 a 36 horas de duración. Paracetamol y ketorolaco le dan alivio parcial y ha faltado varias veces al trabajo. Examen neurológico y fondo de ojo normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar TAC de encéfalo con contraste

B Sumatriptán diario como tratamiento preventivo

C Sumatriptán más antiemético en las crisis y propranolol como profilaxis

D Ketorolaco diario hasta completar 3 meses sin crisis

E Ácido valproico como profilaxis y paracetamol en las crisis

Respuesta C. Migraña sin aura (unilateral, pulsátil, empeora con la actividad, fotofobia + fonofobia + náuseas, 24–36 h) sin banderas rojas: no requiere imagen. Tiene 4–5 crisis al mes con falla de analgésicos: triptán más antiemético en la crisis y profilaxis de primera línea (propranolol si no tiene asma). El sumatriptán no es preventivo, el AINE diario causa cefalea por abuso de medicación y el valproato está proscrito en mujer en edad fértil.

▶ VER CLASE 1.10.1.013 Neuralgia esencial del trigémino

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.7 · Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Neuralgia del trigémino: dolor lancinante como choque eléctrico, de segundos a 2 minutos, en V2–V3 (mejilla, maxilar, mandíbula), unilateral, típico en mayores de 50 años.
- Sello: zonas gatillo (lavarse la cara, afeitarse, cepillarse, masticar, brisa); asintomático entre crisis, sin síntomas autonómicos.
- Sospechar causa secundaria si compromete solo V1, es bilateral, en joven o con déficit sensitivo: esclerosis múltiple o tumor del ángulo pontocerebeloso (RM).
- Tratamiento de elección: carbamazepina 200–1.200 mg/día (alivia >80%); controlar hemograma y natremia. Alternativa oxcarbazepina; segunda línea baclofeno, lamotrigina, gabapentina.
- Diferencial: cefalea en racimos (15–180 min, orbitaria, lagrimeo y rinorrea, hombre fumador: oxígeno 100% + sumatriptán SC).
- Seguimiento: derivar a neurología; si es refractaria, neurocirugía (descompresión microvascular de Jannetta).

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 25

Un paciente de 37 años consulta por dolor en la mandíbula inferior de segundos de duración, muy intenso, EVA 9/10, que se gatilla al comer y al lavarse los dientes. El dolor se ubica en la mitad izquierda de la mandíbula y en la arcada dental inferior izquierda. El examen físico no aporta mayor información. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Neuralgia del trigémino

B Cefalea cluster

C Jaqueca clásica

D Jaqueca complicada

E Disfunción de la articulación temporomandibular

Respuesta A. Dolor de segundos, muy intenso, en el territorio mandibular (V3), gatillado al comer y lavarse los dientes: neuralgia del trigémino. La disfunción temporomandibular da dolor sordo y mantenido al masticar, sin paroxismos eléctricos gatillados por el roce.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 28

Una paciente de 55 años consulta por dolor facial de 3 meses de evolución, de carácter lancinante, que afecta la mejilla y el ala nasal derechas, además del labio superior y la arcada dental del lado derecho. El dolor es muy intenso y se desencadena ante acciones como tocarse la cara, lavarse los dientes y comer, en incluso por una brisa suave. El dolor dura solo unos pocos segundos, sin embargo, su intensidad es muy alta, con EVA 10/10. **¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?**

A Pregabalina

B Amitriptilina

C Venlafaxina

D Carbamazepina

E Tramadol

Respuesta D. Neuralgia del trigémino clásica en V2 (mejilla, ala nasal, labio superior, arcada superior), gatillada por el roce y la brisa. El fármaco de elección es la carbamazepina. La pregabalina es de primera línea en la neuralgia postherpética, no en la del trigémino.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

¿Cuál de las siguientes asociaciones entre cuadro clínico y patología es INCORRECTA? **Seleccione la asociación incorrecta:**

A Cefalea temporoccipital, recurrente, opresiva – Cefalea tensional

B Cefalea hemicránea, pulsátil, recurrente – Jaqueca

C Cefalea progresiva, matinal, con signos focales – Tumor cerebral

D Dolor neurálgico en la mejilla, muy intenso, de segundos de duración – Cluster

E Cefalea muy intensa, de inicio súbito – Hemorragia subaracnoídea

Respuesta D. Un dolor neurálgico en la mejilla, de segundos, es neuralgia del trigémino (V2). El cluster es periorbitario, dura 15 a 180 minutos y se acompaña de síntomas autonómicos ipsilaterales. Las demás asociaciones son correctas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 94

Paciente mujer de 74 años, hipertensa controlada. Presenta dolor de tipo "eléctrico" lascinante en la mejilla y ala nasal izquierda, que compromete la arcada dentaria superior y la encía, así como la zona maxilar superior del lado izquierdo. Además presenta dolor retro ocular izquierdo. El dolor es de escasos segundos, pero intenso EVA 10/10, que se al tacto y al realizar actividades, como cepillarse los dientes e incluso una suave brisa puede desencadenarlo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para este cuadro?

A Pregabalina

B Tramadol

C Prednisona

D Paracetamol y AINEs

E Amoxicilina

Respuesta A. Es una neuralgia del trigémino (dolor eléctrico, de segundos, desencadenado por estímulos leves en territorio V2). El tratamiento de primera línea es carbamazepina; entre las alternativas, el anticonvulsivante útil es la pregabalina. El paracetamol y los AINEs no controlan el dolor neuropático, la prednisona no tiene rol y la amoxicilina no corresponde, pues no es un cuadro dental infeccioso.

▶ VER CLASE 1.10.1.014 Neuropatías por atrapamiento

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.19 · Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Túnel carpiano (mediano): parestesias nocturnas del pulgar a la mitad del anular que alivian al sacudir la mano (Flick); Phalen y Tinel positivos. Factores: mujer, embarazo, diabetes, hipotiroidismo, artritis reumatoide.
- Atrofia tenar o debilidad indican severidad. Confirmar con electromiografía y velocidad de conducción.
- Leve a moderado: férula nocturna con muñeca neutra 4–8 semanas, modificar actividades, infiltración con corticoide; severo o refractario: liberación quirúrgica.
- Ulnar (codo o canal de Guyon): 5° dedo y mitad del 4°, Froment, atrofia hipotenar y garra.
- Peroneo común en el cuello de la fíbula: pie caído con estepaje tras cruzar las piernas, yeso apretado o encamamiento; pierde dorsiflexión y eversión, conserva flexión plantar e inversión.
- Seguimiento: no requiere control especial si responde; derivar si hay déficit motor o atrofia.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 97

Paciente con parestesias nocturnas en una mano que ceden al sacudir las manos. **¿Diagnóstico más probable?**

A Neuropatía cubital

B Síndrome de Raynaud

C Síndrome del túnel carpiano

D Radiculopatía C6

E Polineuropatía diabética

Respuesta C. Parestesias nocturnas que ceden al sacudir la mano (signo de Flick): síndrome del túnel carpiano.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 126

Paciente embarazada de 26 semanas, bien controlada, consulta por cuadro de una semana de sensación de hormigueo en ambas manos de predominio nocturno, mayor en lado derecho, sin otros síntomas. Al examen físico destaca parestesia en ambas manos al mantener muñecas flexionadas por 20 segundos. **El diagnóstico más probable:**

A Mielopatía cervical

B Polimiositis

C Miastenia gravis

D Atrapamiento del nervio cubital

E Atrapamiento del nervio mediano

Respuesta E. Embarazada con parestesias nocturnas en las manos y signo de Phalen positivo: túnel carpiano, es decir, atrapamiento del nervio mediano.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 111

Un paciente de 55 años con diabetes mellitus mal controlada con metformina consulta por disestesias y sensación de aumento de volumen o edema en ambas manos, de predominio nocturno, que disminuyen con el movimiento y ceden al iniciar sus actividades diarias. El examen físico muestra movilidad y sensibilidad conservadas, con leve atrofia de la eminencia tenar. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Neuropatía diabética simétrica sensitiva
B Contractura de Dupuytren
C Atrapamiento de los dedos flexores de la mano
D Artritis reumatoide
E Síndrome del túnel carpiano

Respuesta E. Síntomas nocturnos en las manos que ceden con el movimiento y atrofia tenar, en un diabético: túnel carpiano. La neuropatía diabética parte por los pies.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 30

Un paciente de 65 años, alcohólico inveterado, se queda dormido sobre el costado derecho, mientras estaba borracho. Al despertar, al día siguiente, no puede mover la mano derecha. Al examen neurológico, no puede extender los dedos ni la muñeca, aunque puede flectarlos sin problemas. Además no tiene alteraciones visuales ni afasia. **El diagnóstico más probable es:**

A Hematoma subdural izquierdo
B Trombosis de la vena subclavia
C Neuropatía compresiva del nervio radial
D Trombosis de la arteria subclavia
E Hematoma capsular izquierdo

Respuesta C. Es una presentación clásica de neuropatía compresiva del nervio radial, la llamada parálisis del borracho.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 58

Un paciente de 63 años, diabético mal controlado, presenta parestesias, asociada a dolor en ambas manos, que es mayor en la noche y que se irradia a ambos codos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Polineuropatía diabética
B Hernia del núcleo pulposo
C Síndrome de túnel carpiano
D Síndrome de atrapamiento cubital
E Neuropatía radial

Respuesta C. Parestesias y dolor nocturno bilateral en las manos en un diabético mal controlado son más compatibles con un síndrome de túnel carpiano bilateral, frecuente en la diabetes, cuyo dolor puede irradiarse hacia el antebrazo y el codo. El atrapamiento cubital produce síntomas en el cuarto y quinto dedos y suele ser unilateral, y la polineuropatía diabética afecta primero los pies. La radiculopatía por hernia y la neuropatía radial no explican el cuadro.

▶ VER CLASE **1.10.1.015** **Parálisis (tetraparesia, hemiparesia, etc)** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.16 · Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Localizar la lesión según el patrón: hemiparesia (hemisferio o tronco contralateral), paraparesia (médula), tetraparesia (médula cervical, tronco o nervio periférico/placa), monoparesia (corteza o nervio).
- Primera motoneurona: espasticidad, hiperreflexia y Babinski (en agudo puede haber flacidez por shock). Segunda motoneurona: flacidez, arreflexia, atrofia y fasciculaciones.
- Nivel sensitivo y trastorno esfinteriano = lesión medular: RM urgente (compresión neoplásica: dexametasona antes de la RM).
- Hemiparesia súbita = ACV: código ACV y TAC sin contraste. Tetraparesia ascendente arrefléctica = Guillain-Barré; con reflejos vivos, pensar en médula.
- Debilidad fluctuante y fatigable con pupilas normales = miastenia; proximal simétrica con CK alta = miopatía; con hipokalemia, parálisis periódica.
- No requiere seguimiento por el médico general: estabilizar y derivar según la causa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 57

Un hombre de 58 años presenta un cuadro de 3 años de evolución de debilidad progresiva de las extremidades que le dificulta caminar, hasta no poder hacerlo, a lo que luego se agrega dificultad para tragar. Evoluciona finalmente con dificultad respiratoria y necesidad de traqueostomía. No tiene alteración sensitiva. La espirometría muestra un patrón restrictivo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Polineuropatía diabética
B Distrofia muscular
C Esclerosis múltiple
D Miastenia gravis
E Esclerosis lateral amiotrófica

Respuesta E. Debilidad progresiva de extremidades con compromiso bulbar (disfagia) y respiratorio, sin alteración sensitiva, en un adulto, sugiere esclerosis lateral amiotrófica, con signos de primera y segunda motoneurona. La espirometría restrictiva refleja la debilidad diafragmática. La polineuropatía diabética es predominantemente sensitiva y la miastenia es fluctuante y fatigable.

▶ VER CLASE `1.10.1.016` **Parálisis facial periférica** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.19 · Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento
Otorrino 14.8 · Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Síndrome de Ramsay Hunt

QUÉ HAY QUE SABER

- Periférica: compromete toda la hemicara del mismo lado (no arruga la frente, lagoftalmos con signo de Bell, comisura caída). Central: respeta frente y cierre ocular, con hemiparesia = ACV, TAC urgente.
- Bell (idiopática, 60–75%): instalación en 1–2 días, dolor retroauricular previo, hiperacusia y ageusia de 2/3 anteriores.
- Tratamiento: prednisona 60 mg/día (1 mg/kg) por 7 días con descenso, idealmente antes de 72 h; antivirales no de rutina.
- Protección ocular obligatoria: lágrimas artificiales cada 1–2 h, ungüento y oclusión nocturna (riesgo de queratitis por exposición).
- Ramsay Hunt (vesículas en concha o conducto, otalgia, puede haber hipoacusia o vértigo): prednisona + valaciclovir 1 g c/8 h por 7–10 días; peor pronóstico.
- Seguimiento completo: >85% mejora en 3 semanas; derivar si es bilateral (pensar en Guillain-Barré), recurrente, con otros pares, masa parotídea o sin mejoría a los 3 meses.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 19 años consulta por imposibilidad de mover la mitad de la cara izquierda, que inició hace 3 horas. Presenta sensibilidad normal y conserva los movimientos masticatorios y oculomotores, sin embargo no es capaz de realizar movimientos con los músculos de expresión facial del lado izquierdo como sonreír, fruncir el ceño, arrugar la frente y tampoco puede cerrar completamente el ojo. El resto del examen neurológico es normal. **Además de la protección ocular la conducta más adecuada es:**

A Iniciar carbamazepina
B Iniciar clorpromazina
C Iniciar amitriptilina
D Iniciar aciclovir
E Iniciar prednisona

Respuesta E. Parálisis facial periférica aguda (incluye la frente y el cierre ocular) sin otros hallazgos: parálisis de Bell. El tratamiento es prednisona precoz, dentro de las primeras 72 horas. El aciclovir no se recomienda de rutina.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 60 años consulta en urgencia por desviación de la comisura bucal hacia la derecha y dificultad para pronunciar las palabras desde hace 2 horas. Al examen físico se aprecia incapacidad para elevar la comisura labial izquierda; sin embargo, el paciente arruga la frente de forma perfectamente simétrica y ocluye ambos ojos con fuerza normal sin lagoftalmos. **¿Cuál es la localización topográfica más probable de la lesión y la conducta inmediata?**

A Lesión del nervio facial periférico izquierdo en el foramen estilomastoideo; indicar prednisona oral ambulatoria
B Lesión corticonuclear o hemisférica cerebral derecha (parálisis facial central); activar código de sospecha de ACV y solicitar TAC de cerebro de urgencia
C Síndrome de Ramsay Hunt atípico; iniciar valaciclovir oral en altas dosis
D Parálisis de Bell de curso frustro; indicar reposo y control ambulatorio en una semana
E Otitis media aguda complicada con compresión del canal de Falopio; solicitar TAC de peñasco

Respuesta B. La frente está respetada y no hay lagoftalmos: es una parálisis facial central. Por la doble inervación corticonuclear de la frente, una lesión hemisférica unilateral la respeta. Requiere código ACV y TAC de cerebro urgente. Tratarla como Bell con corticoides ambulatorios es un error grave.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 38 años consulta por asimetría facial de instalación rápida en las últimas 24 horas. No puede cerrar el ojo derecho y al tomar líquidos se le escapan por la comisura derecha. Tiene borramiento de los pliegues de la frente derecha, con imposibilidad de arrugarla o levantar la ceja, lagoftalmos derecho y desviación de la comisura hacia la izquierda al sonreír. El resto del examen neurológico es normal. La otoscopía es normal y no hay vesículas. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Valaciclovir 1 g cada 8 horas, sin corticoides

B Prednisona 1 mg/kg/día por 7 a 10 días, lágrimas artificiales y parche ocular nocturno

C TAC de cerebro urgente y activar código ACV

D Observación sin tratamiento por 2 semanas

E Ciprofloxacino tópico en el oído

Respuesta B. No arruga la frente y tiene lagoftalmos: parálisis periférica. Sin vesículas ni otalgia, es una parálisis de Bell. Se trata con prednisona 1 mg/kg/día por 7 a 10 días dentro de las primeras 72 horas, más protección ocular. Los antivirales solos no sirven y el código ACV corresponde a la parálisis central.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 22 años, sano, despierta con "la cara chueca". Ayer tuvo molestia retroauricular derecha. No eleva la ceja ni arruga la frente a derecha; al cerrar los ojos con fuerza el ojo derecho queda entreabierto 4 mm y el globo sube dejando ver la esclerótica. La comisura se desvía a la izquierda. Resto de pares, fuerza, sensibilidad y reflejos normales. Conducto auditivo sin vesículas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A TAC de encéfalo urgente y activar protocolo de ACV

B Prednisona 60 mg/día por 7 días con descenso, más protección ocular

C Aciclovir oral como tratamiento único

D Prednisona más valaciclovir por Ramsay Hunt

E Observar, porque más del 85% mejora solo

Respuesta B. Compromiso de toda la hemicara, incluida la frente, con lagoftalmos y signo de Bell y sin otros hallazgos: parálisis facial periférica idiopática (Bell). Se trata con prednisona precoz (<72 h) y protección ocular obligatoria. La TAC es para la parálisis central (frente preservada); el antiviral, para el Ramsay Hunt (vesículas).

▶ VER CLASE 1.10.1.017 Polineuropatías, radiculopatías, mononeuropatías, etc...

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.16 · Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Polineuropatía: distal, simétrica y largo-dependiente; parestesias y dolor urente en calcetín y guante, aquilianos disminuidos con rotulianos conservados.
- Causas: diabetes (la más frecuente), alcohol, déficit de B12, hipotiroidismo, ERC, VIH, fármacos (quimioterapia, isoniazida); pedir glicemia/HbA1c, B12, TSH, creatinina.
- Radiculopatía: dolor que sigue un dermatoma, con déficit en el miotoma y reflejo de esa raíz (hernia discal). Mononeuropatía: territorio de un nervio (túnel carpiano, peroneo, III par diabético).
- Polineuropatía aguda ascendente motora y arrefléctica = Guillain-Barré (urgencia).
- Manejo inicial: tratar la causa (control glicémico, B12, suspender alcohol), cuidado de pies con monofilamento en diabéticos, dolor neuropático con pregabalina, gabapentina o amitriptilina.
- No requiere seguimiento especial por el médico general salvo el de la causa; EMG con velocidad de conducción si hay duda diagnóstica.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 44

Un paciente diabético de larga data, mal controlado, en tratamiento con metformina y empaglifozina. Consulta por ptosis y molestias visuales en el ojo derecho. Al examen físico, tiene ptosis del ojo derecho, que se asocia a diplopía al abrir manualmente el párpado. Además, tiene dificultades en la aducción y elevación del ojo derecho. Su agudeza visual se constata como 20/25 bilateral. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Accidente vascular encefálico

B Tumor cerebral

C Cáncer de pulmón con compromiso del ganglio estrellado

D Ptosis aponeurótica

E Parálisis del tercer nervio craneal

Respuesta E. Ptosis con déficit de aducción y elevación de un solo ojo, en un diabético mal controlado: parálisis del III par (mononeuropatía diabética). A diferencia de la miastenia, el compromiso sigue el territorio de un solo nervio y no fluctúa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 59

Paciente de 70 años consulta por dolor tipo urente en las extremidades inferiores, asociado a parestesias descritas como hormigueos en los pies. Al examen físico tiene disminución de la sensibilidad en calcetín, con paresia a la extensión de los ortejos y disminución de ambos reflejos aquilianos. En cambio, los reflejos rotulianos se encuentran conservados. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Radiculopatía S1 bilateral
B Síndrome de cauda equina
C Síndrome del cono medular
D Síndrome de Guillain-Barré
E Polineuropatía

Respuesta E. Dolor urente y parestesias distales, hipoestesia en calcetín, debilidad distal y aquilianos disminuidos con rotulianos conservados: compromiso distal, simétrico y largo-dependiente, típico de polineuropatía. La radiculopatía sigue un dermatoma; la cauda equina y el cono dan anestesia en silla de montar y trastornos esfinterianos; el Guillain-Barré es agudo, motor y ascendente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 23

Un paciente de 69 años presenta debilidad de las manos, asociados a disminución de la sensibilidad de manos y pies. Refiere además dolor tipo ardor en las extremidades inferiores. Al examen físico tiene disminución de la sensibilidad “en calcetín”, signo de Lasegue negativo y presenta abolición de ambos reflejos aquileanos. El diagnóstico más probable es:

A Síndrome de Guillain Barré
B Radiculopatía S1
C Síndrome de cola de caballo
D Polineuropatía
E Esclerosis lateral amiotrófica

Respuesta D. Diagnóstico: Polineuropatía (opción D). Cuadro clásico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 119

Hombre de 55 años con diabetes mellitus de larga data. Presenta debilidad asimétrica en extremidades, afectando nervio peroneo derecho y cubital izquierdo. Sin compromiso de pares craneanos. ¿Cuál es el diagnóstico?

A Mononeuritis múltiple
B Polineuropatía diabética simétrica
C Síndrome de Guillain-Barré
D ACV múltiple
E Miopatía inflamatoria

Respuesta A. Afectación de nervios periféricos individuales, no contiguos y asimétricos en diabético = mononeuritis múltiple (mononeuropatía múltiple). Causas: diabetes, vasculitis, lepra.

▶ VER CLASE `1.10.1.018` **Síndrome atáxico** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.20 · Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome atáxico cerebeloso: marcha de base amplia, dismetría (índice-nariz), disdiadococinesia, temblor de intención, nistagmo y disartria escandida; lesión hemisférica da signos ipsilaterales.
- Ataxia sensitiva (cordones posteriores): Romberg positivo, pérdida de vibración y posición (déficit de B12, tabes). Vestibular: vértigo, con lateropulsión.
- Agudo con vértigo, cefalea occipital e imposibilidad de pararse = ACV o hemorragia cerebelosa: TAC/RM urgente (hematoma ≥3 cm se opera por compresión de tronco e hidrocefalia).
- Otras causas: alcohol (degeneración vermiana), fármacos (fenitoína, litio), Wernicke (ataxia + oftalmoplejía + confusión: tiamina EV), esclerosis múltiple, tumores de fosa posterior, paraneoplásica, hereditarias.
- Manejo inicial: suspender tóxicos, tiamina en alcohólicos, corregir B12 y neuroimagen.
- No requiere seguimiento por el médico general: derivar a neurología.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años, hipertenso, presenta en forma súbita vértigo, vómitos, cefalea occipital e imposibilidad de mantenerse de pie. Al examen tiene dismetría en la prueba índice-nariz y disdiadococinesia derechas, marcha con lateralización a derecha y nistagmo que cambia de dirección con la mirada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Maniobra de Epley

B Betahistina y control ambulatorio

C Corticoides por neuronitis vestibular

D Audiometría

E Neuroimagen urgente (TAC o resonancia de cerebro) por sospecha de lesión cerebelosa

Respuesta E. Un síndrome atáxico agudo con dismetría y disdiadococinesia ipsilaterales, cefalea y nistagmo que cambia de dirección es de origen central: debe descartarse hemorragia o infarto cerebeloso con neuroimagen urgente, porque el edema puede comprimir el tronco y causar hidrocefalia, requiriendo cirugía. Epley y betahistina son para cuadros periféricos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 89

Un paciente de 75 años, con antecedente de EPOC en tratamiento con broncodilatadores inhalados y bromhexina 8mg cada 8h, más consumo de alcohol de una botella de vino de 750 cc durante los fines de semana, consulta por dificultades para caminar y hablar de 3 meses de evolución, progresivas, asociadas a torpeza de las extremidades. No ha presentado náuseas ni cefalea. Al examen físico, se aprecia ataxia de la marcha, habla disártrica y dismetría de las extremidades superiores, con imposibilidad de realizar movimientos alternantes de forma coordinada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Toxicidad cerebelosa por bromhexina

B Degeneración cerebelosa alcohólica

C Esclerosis múl2ple

D Síndrome paraneoplásico

E Tumor cerebeloso

Respuesta D. Pregunta muy difícil, aunque Gene un claro síndrome cerebeloso. Sin embargo, no queda clara la causa. Tiene factores de riesgo para cáncer pulmonar, que puede producir una cerebelitis autoinmune, siendo compatible el cuadro con la velocidad que se instauró. No Gene náuseas ni cefalea para pensar en un tumor. El consumo de alcohol no es muy grande y el daño cerebeloso por alcohol suele ser de instalación mucho más lenta. La bromhexina no suele producir toxcicidad cerebelosa y, en caso de...

▶ VER CLASE 1.10.1.019 Síndrome de hipertensión endocraneana

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.5 · Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena
Oftalmología 15.18 · Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipertensión endocraneana: cefalea progresiva de predominio matinal que empeora con Valsalva y decúbito, vómitos (explosivos), oscurecimientos visuales y diplopía por VI par (falsa localización).
- Fondo de ojo: edema de papila bilateral (papilas solevantadas, bordes borrosos, sin pulso venoso, hemorragias peripapilares), con agudeza visual conservada al inicio.
- Signos de herniación: compromiso de conciencia, midriasis unilateral y tríada de Cushing (HTA, bradicardia, respiración irregular).
- Neuroimagen urgente antes de cualquier punción lumbar (riesgo de herniación): tumor, hematoma, hidrocefalia, absceso, trombosis venosa (angio-RM venosa); hipertensión intracraneal idiopática en mujer joven obesa.
- Medidas iniciales: cabecera a 30°, vía aérea, normoventilación, manitol o suero hipertónico; dexametasona si hay edema vasogénico por tumor; evitar sueros hipotónicos.
- No requiere seguimiento del médico general: derivar a neurocirugía o neurología según la causa.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 169

Una paciente de 45 años, con antecedente de hipertensión arterial y migraña tratada con antiinflamatorios y ergotamínicos, consulta por cefalea más intensa de lo habitual, desde hace dos meses, que inicialmente era mayor durante la mañana, pero que ha aumentado en intensidad durante todo el día y se ha asociado a náuseas y vómitos explosivos. Refiere no haber tenido respuesta a pesar del uso frecuente de analgésicos y ergotamínicos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Síndrome de hipertensión endocraneana

B Hemorragia subaracnoidea

C Encefalopatía hipertensiva

D Tumor cerebral

E Cefalea por ergotamínicos

Respuesta A. Una migrañosa con cambio de patrón: cefalea progresiva, de predominio matinal, con vómitos explosivos y sin respuesta al tratamiento habitual. Son banderas rojas (letra P de SNOOP10) de hipertensión endocraneana: fondo de ojo y neuroimagen. La cefalea por abuso de medicación no explica los vómitos explosivos ni el predominio matinal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 169

Paciente de 45 años, con antecedente de hipertensión arterial y migraña tratada con antiinflamatorios y ergotamínicos, consulta por cefalea más intensa de lo habitual desde hace 2 meses, que inicialmente predominaba en la mañana, pero que ha aumentado en intensidad durante todo el día y se ha asociado a náuseas y vómitos explosivos. Refiere no haber tenido respuesta a pesar del uso frecuente de analgésicos y ergotamínicos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Síndrome de hipertensión endocraneana
B Hemorragia subaracnoídea
C Encefalopatía hipertensiva
D Tumor cerebral
E Cefalea por ergotamínicos

Respuesta A. Cefalea progresiva de predominio matinal, con náuseas y vómitos explosivos y sin respuesta a analgésicos: síndrome de hipertensión endocraneana (cefalea matinal, vómitos y edema de papila). Obliga a fondo de ojo y neuroimagen. El tumor es una causa posible, pero el diagnóstico sindromático es la HTEC; la hemorragia subaracnoídea es súbita, no de 2 meses.

▶ VER CLASE 1.10.1.020 Síndrome miasténico

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.17 · Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma

QUÉ HAY QUE SABER

- Miastenia gravis: debilidad fatigable (peor con el uso y en la tarde, mejora con reposo); ptosis asimétrica y diplopía que no calzan con un par, voz nasal, fatiga al masticar, debilidad proximal.
- Pupilas siempre normales: ptosis con midriasis descarta miastenia (pensar en III par por aneurisma, botulismo). Reflejos y sensibilidad normales.
- Pruebas de cabecera: test del hielo (mejora ≥2 mm) y Simpson; confirmar con anticuerpos anti-receptor de ACh (si negativos, anti-MuSK) y estimulación repetitiva (decremento >10%).
- TAC de tórax obligatorio en todos (timoma 10–15%). Tratamiento sintomático con piridostigmina 30–60 mg c/4–6 h.
- Evitar fármacos que la descompensan: aminoglucósidos, quinolonas, macrólidos, betabloqueadores, sulfato de magnesio EV.
- Crisis miasténica (falla respiratoria, disfagia grave): UCI, intubación precoz, plasmaféresis o inmunoglobulina. Seguimiento por neurología.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 74

Una paciente de 38 años, profesora de enseñanza básica, consulta por debilidad y mialgias generalizadas, que iniciaron hace 1 mes. Además, refiere ptosis a derecha, que suele ser mayor en las tardes. Al examen físico se constata ptosis bilateral, mayor a derecha, con normalidad de los reflejos osteotendíneos y la sensibilidad. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Esclerosis lateral amiotrófica
B Polimiositis
C Síndrome de Guillain Barré
D Esclerosis múltiple
E Miastenia gravis

Respuesta E. Ptosis fluctuante, que empeora con el uso y en la tarde, con reflejos y sensibilidad normales: es el cuadro clásico de miastenia gravis, una falla de la placa neuromuscular. Y aquí conecta con el mediastino: frente a una miastenia gravis hay que buscar un timoma, con TAC de tórax con contraste.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 29 años, cajera, con 3 semanas de ptosis y diplopía que aparecen al avanzar la jornada; amanece casi asintomática. Se le cansa la mandíbula al masticar y la voz se vuelve gangosa en la tarde. Ptosis bilateral de predominio izquierdo, pupilas isocóricas y reactivas. El test del hielo mejora la hendidura palpebral 3,5 mm. Reflejos y sensibilidad normales. **Además de iniciar piridostigmina, ¿qué estudio es obligatorio solicitar?**

A Angiografía cerebral por sospecha de aneurisma de comunicante posterior
B Punción lumbar para buscar disociación albúmino-citológica
C Anticuerpos anti-receptor de acetilcolina y TAC de tórax con contraste
D Resonancia magnética de cerebro con gadolinio
E Creatinquinasa y biopsia muscular

Respuesta C. Fatigabilidad vespertina ocular y bulbar, pupilas normales y test del hielo positivo: miastenia gravis. Se confirma con anti-AChR (y anti-MuSK si es negativo) y electromiografía con estimulación repetitiva, y la TAC de tórax es obligatoria en todos para buscar timoma. Con pupilas normales no se sospecha aneurisma; la punción lumbar es para Guillain-Barré.

▶ VER CLASE 1.10.1.021 Síndrome miopático (distrofias musculares, polimiositis)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.13 · Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome miopático: debilidad proximal y simétrica de cinturas (dificultad para levantarse, subir escaleras, peinarse), con sensibilidad y reflejos conservados y sin compromiso ocular.

- Dermatomiositis: heliotropo y pápulas de Gottron; polimiositis sin piel. CK 10–50 veces lo normal; complicaciones: enfermedad pulmonar intersticial (anti-Jo1), disfagia y miocarditis.
- En adultos (sobre todo >50 años) tamizar cáncer oculto (25–30%): TAC de tórax-abdomen-pelvis, mamografía, ecografía transvaginal, endoscopías.
- Distrofias musculares: hereditarias, inicio en la infancia (Duchenne: varón, Gowers, pseudohipertrofia de pantorrillas, CK muy alta).
- Descartar causas tóxicas y metabólicas: estatinas (medir CK), hipotiroidismo (TSH), corticoides, alcohol, hipokalemia.
- Confirmación con EMG, RM muscular y biopsia (patrón oro); no requiere seguimiento por el médico general: derivar a reumatología o neurología.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2019 · PREGUNTA 15

¿Cuál de las siguientes características anatomopatológicas e inmunohistoquímicas es típica de la biopsia muscular en una POLIMIOSITIS, permitiendo diferenciarla de la dermatomiositis?

A Atrofia perifascicular prominente con depósito vascular de complemento C5b-9

B Infiltrado inflamatorio endomisial compuesto por linfocitos T citotóxicos CD8+ que invaden miofibras

C Infiltración exclusiva de eosinófilos con vasculitis necrotizante transmural

D Depósito masivo de sustancia amiloide rojo Congo positiva en el endomisio

E Ausencia total de células inflamatorias con degeneración grasa aislada

Respuesta B. En la polimiositis el mecanismo inmune es una citotoxicidad celular directa mediada por linfocitos T CD8+ que infiltran el endomisio e invaden activamente miofibras no necróticas que sobreexpresan antígenos HLA clase I. En cambio, la dermatomiositis es una microangiopatía mediada por complemento/anticuerpos que produce atrofia perifascicular e infiltrado perimisial por linfocitos CD4+ y B.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2024 · PREGUNTA 20

¿Cuál de los siguientes grupos musculares se encuentra característicamente RESPETADO en la polimiositis y dermatomiositis, orientando el diagnóstico hacia Miastenia Gravis si se encuentra afectado?

A Músculos deltoides y supraespinoso

B Músculos psoas ilíaco y cuádriceps femoral

C Músculos flexores profundos del cuello

D Músculos extraoculares y palpebrales intrínsecos

E Músculos constrictores de la faringe

Respuesta D. Las miopatías inflamatorias autoinmunes afectan típicamente la musculatura estriada proximal de las cinturas escapular y pelviana, flexores del cuello y faringe, pero RESPETAN de forma estricta los músculos extraoculares y la musculatura facial. La presencia de ptosis palpebral fluctuante o diplopía es característica de la Miastenia Gravis, no de la polimiositis ni dermatomiositis.

▶ VER CLASE 1.10.1.022

Síndromes convulsivos sintomáticos (traumático, tumores SNC, metabólico, etc)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.10 · Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Crisis sintomática aguda (provocada): ocurre en relación temporal con una noxa aguda; no es epilepsia y no requiere antiepiléptico crónico.
- Causas metabólicas: hipoglicemia (<50 mg/dL; glibenclamida, insulina), hiponatremia (<120 o rápida), hipocalcemia, uremia, encefalopatía hepática.
- Tóxicas y estructurales agudas: abstinencia alcohólica (24–48 h), cocaína, meningitis o encefalitis, TEC, ACV, tumor o neurocisticercosis (lesión quística con eosinófilos en LCR).
- Estudio en toda primera crisis: glicemia capilar inmediata, electrolitos (Na, K, Ca, Mg), función renal y hepática, tóxicos, ECG y TAC sin contraste; RM ambulatoria.
- Tratar la causa: glucosa (con tiamina previa en alcohólicos), corregir sodio lentamente, benzodiacepinas en abstinencia; si la crisis dura ≥5 min, protocolo de estatus.
- Seguimiento: derivar a neurología si hay lesión estructural (tumor, secuela de TEC) que dé riesgo de epilepsia; indicar no conducir mientras se estudia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 62 años, diabético usuario de insulina, presenta una crisis tónico-clónica generalizada en su casa. Al llegar el SAMU tiene glicemia capilar de 28 mg/dL; se administra glucosa endovenosa y recupera completamente la conciencia. Examen neurológico normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la crisis?**

A Iniciar ácido valproico de mantención

B Diagnosticar epilepsia del adulto

C Iniciar levetiracetam por al menos 2 años

D Resonancia y electroencefalograma antes de reiniciar la insulina

E Corregir la causa y ajustar el tratamiento de la diabetes, sin fármaco antiepiléptico crónico

Respuesta E. Una crisis desencadenada por una alteración metabólica aguda (hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, abstinencia alcohólica) es una crisis sintomática aguda, no epilepsia. Se trata corrigiendo la causa y previniendo que se repita; no requiere antiepiléptico de mantención, porque el riesgo de recurrencia depende de la causa.

▶ VER CLASE 1.10.1.023 Síndromes sensitivos (polineuropatía, hemihipoestesia, dolor talámico, etc)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.6 · Anemias Macrocíticas y Megaloblásticas: Déficit de B12 (Anemia Perniciosa/Neuropatía) vs Déficit de Folato

QUÉ HAY QUE SABER

- Localizar por el patrón sensitivo: polineuropatía en guante y calcetín (diabetes, alcohol, B12), radicular por dermatoma, nivel sensitivo en el tronco (médula), hemihipoestesia (tálamo o corteza contralateral).
- Déficit de B12: degeneración combinada subaguda con pérdida de vibración y posición, Romberg positivo, ataxia y signos piramidales, más parestesias distales; causas: anemia perniciosa, gastrectomía, metformina o IBP prolongados.
- Disociación sensitiva: termoalgésica con tacto conservado (siringomielia, en capa), síndrome de Brown-Séquard (propioceptiva ipsilateral y termoalgésica contralateral).
- Dolor talámico (Dejerine-Roussy): dolor urente contralateral tras un infarto talámico; tratar con amitriptilina, gabapentina o pregabalina.
- Manejo inicial: B12 sérica, glicemia, TSH; B12 1.000 µg IM diario por 7 días, luego semanal y mensual de por vida en malabsorción; nunca ácido fólico solo (empeora lo neurológico).
- Hemihipoestesia súbita = ACV (código ACV); nivel sensitivo agudo = RM urgente. Sin seguimiento especial del médico general salvo la causa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 66 años, vegana estricta desde hace 15 años y usuaria de metformina, consulta por hormigueo en pies y manos e inestabilidad al caminar en la oscuridad. Al examen tiene pérdida de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva en extremidades inferiores, Romberg positivo y reflejos aquilianos disminuidos. Hemoglobina 11,2 g/dL, VCM 104 fL. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Polineuropatía diabética

B Degeneración combinada subaguda por déficit de vitamina B12

C Ataxia cerebelosa alcohólica

D Síndrome de Guillain-Barré

E Esclerosis múltiple

Respuesta B. Compromiso de cordones posteriores (pérdida vibratoria y propioceptiva, Romberg positivo, ataxia sensitiva) con macrocitosis en una vegana usuaria de metformina sugiere déficit de vitamina B12. Se confirma con niveles de B12 y ácido metilmalónico y se trata con B12 parenteral. La polineuropatía diabética no explica la macrocitosis, y la ataxia cerebelosa tiene Romberg negativo.

▶ VER CLASE 1.10.1.024 Síndromes vertiginosos centrales

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.20 · Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS

QUÉ HAY QUE SABER

- Vértigo central (urgencia vital): no puede mantenerse de pie, ataxia desproporcionada, focalidad de tronco o cerebelo (diplopía, disartria, disfagia, dismetría), nistagmo vertical o que cambia de dirección y no se inhibe al fijar la mirada.
- En el síndrome vestibular agudo (vértigo continuo de días) aplicar HINTS: impulso cefálico normal, nistagmo que cambia de dirección o skew positivo = central; basta un signo.
- La TAC detecta <15–20% de los infartos de fosa posterior y la RM con difusión tiene falsos negativos en las primeras 24–48 h: una imagen normal no descarta ACV.
- Causas: infarto o hemorragia cerebelosa o de tronco (PICA, AICA), esclerosis múltiple, tumores de fosa posterior, migraña vestibular.
- Conducta: código ACV, hospitalizar en UTAC (GES), angio-RM urgente; hematoma cerebeloso ≥3 cm es indicación quirúrgica.
- No requiere seguimiento del médico general: derivar a neurología.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 29

Un paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial sin tratamiento, consulta por vértigo intenso de inicio súbito hace 2 horas, asociado a dificultades en la marcha que le impiden mantenerse de pie. Al examen físico se observa hipotónico, con dismetría de extremidades y nistagmus multidireccional. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar difenidol

B Realizar examen de VIII par

C Solicitar prueba calórica

D Solicitar resonancia magnética nuclear de troncoencéfalo

E Solicitar TAC de cerebro

Respuesta E. Vértigo central: súbito, con incapacidad para la bipedestación, dismetría y nistagmo multidireccional en un hipertenso. La primera sospecha es un ACV cerebeloso o vertebrobasilar, y lo urgente es la TAC de cerebro: rápida, detecta la hemorragia (que, si es cerebelosa ≥ 3 cm, se opera) y, si no hay sangre, permite evaluar trombólisis. La resonancia ve mejor la fosa posterior, pero viene después.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años, hipertenso y diabético, con vértigo continuo desde hace 10 horas, vómitos e inestabilidad. No puede mantenerse de pie sin apoyo. Sin hipoacusia. Impulso cefálico sin sacada correctiva hacia ambos lados; nistagmo horizontal que bate a la derecha al mirar a la derecha y a la izquierda al mirar a la izquierda. TAC de encéfalo sin contraste normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Dimenhidrinato EV y alta con control, porque la TAC es normal

B Maniobra de Epley

C Activar código ACV, hospitalizar en UTAC y angio-RM urgente

D Betahistina 24 mg c/12 h y restricción de sal

E Sedantes vestibulares por 3 semanas y rehabilitación vestibular

Respuesta C. Síndrome vestibular agudo en un paciente vascular con HINTS central: impulso cefálico normal y nistagmo que cambia de dirección, más incapacidad de mantenerse de pie. La TAC normal no descarta un infarto de fosa posterior: se activa el código ACV, se hospitaliza en UTAC (GES 37) y se pide angio-RM urgente.

▶ VER CLASE 1.10.1.025 Síndromes vertiginosos periféricos

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.20 · Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS
Otorrino 14.7 · Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière

QUÉ HAY QUE SABER

- Periférico: brusco, intenso, con muchos vómitos, camina aunque se ladee, nistagmo horizontal-rotatorio unidireccional que se inhibe al fijar la mirada; puede tener síntomas auditivos.
- VPPB (el más frecuente): episodios de segundos al girar en la cama o mirar arriba; Dix-Hallpike con latencia, nistagmo torsional y fatigable; tratar con maniobra de Epley (cura >80–90%), sin fármacos ni imágenes.
- Neuronitis vestibular: vértigo continuo de días, sin hipoacusia; sedantes vestibulares (dimenhidrinato 50 mg c/8 h) solo 48–72 h y prednisona precoz.
- Menière: crisis de 20 min a 12 h con hipoacusia fluctuante de tonos graves, tinnitus y plenitud ótica; sal <2 g/día, diurético y betahistina 24 mg c/12 h.
- Siempre aplicar HINTS en el vértigo continuo: impulso cefálico normal, nistagmo que cambia de dirección o skew = central (código ACV).
- Seguimiento completo: rehabilitación vestibular, evitar sedantes prolongados; audiometría en Menière y derivar a ORL si recurrente o refractario.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 38 años consulta en urgencia por vértigo rotatorio continuo de 24 horas, con náuseas y múltiples vómitos, que le impide caminar. Una semana antes tuvo un resfrío. No tiene hipoacusia ni acúfenos. Presenta nistagmo horizontal unidireccional hacia la derecha, que aumenta al mirar a la derecha, impulso cefálico anormal con sacada correctiva hacia la izquierda y test de skew negativo. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Maniobra de Epley en la consulta

B Dimenhidrinato por 48 horas y prednisona 1 mg/kg/día por 7 días

C Dieta con sodio menor de 2 g/día e hidroclorotiazida

D Sedantes vestibulares por 4 semanas para evitar recurrencias

E Hospitalizar por sospecha de ACV de fosa posterior

Respuesta B. Es una neuronitis vestibular, con HINTS periférico: impulso cefálico anormal, nistagmo unidireccional horizontal y skew negativo. Se trata con antieméticos o sedantes vestibulares solo por 48 horas, para no frenar la compensación central, más prednisona 1 mg/kg/día por 7 días. Epley es para el VPPB y la dieta sin sal para Ménière.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 57 años con 5 días de episodios de vértigo rotatorio intenso de menos de 1 minuto, que aparecen al darse vuelta en la cama o al mirar hacia arriba, con náuseas. Sin hipoacusia, tinnitus ni síntomas neurológicos. Examen neurológico normal. Maniobra de Dix-Hallpike derecha: tras una latencia de 5 segundos, nistagmo torsional geotrópico y vertical hacia arriba, que dura 20 segundos y se agota al repetirla. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Betahistina 24 mg cada 12 horas por 3 meses

B Dimenhidrinato diario por 3 semanas

C RM de encéfalo urgente

D Prednisona oral por 10 días

E Maniobra de reposición de Epley

Respuesta E. Vértigo posicional breve con Dix-Hallpike positivo (latencia, nistagmo torsional geotrópico, duración menor de 1 minuto y fatigable): vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular posterior derecho. Se trata con la maniobra de reposición de Epley, efectiva en la mayoría con 1 o 2 sesiones. Los sedantes vestibulares retrasan la compensación; no requiere imagen.

▶ VER CLASE 1.10.1.026 Temblor esencial

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.13 · Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Temblor esencial: el trastorno del movimiento más frecuente; postural y de acción (sopa, vaso, escritura), bilateral, 8–12 Hz, puede afectar cabeza (no-no) y voz.

- Claves: antecedente familiar (autosómico dominante), mejora con alcohol, examen neurológico normal sin bradicinesia ni rigidez; nunca temblor de pierna en reposo.
- Descartar temblor fisiológico exagerado: hipertiroidismo (TSH), cafeína, ansiedad, abstinencia alcohólica y fármacos (salbutamol, litio, valproato, levotiroxina en exceso).
- Diferencial con Parkinson: temblor de reposo asimétrico que cede al moverse, con bradicinesia y rigidez.
- Tratamiento inicial si afecta la vida diaria: propranolol 40–160 mg/día (contraindicado en asma, bloqueo AV, bradicardia); alternativa primidona 25–250 mg en la noche.
- No requiere seguimiento especial: ajustar dosis según respuesta; derivar si es refractario o atípico.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 161

Paciente masculino, de 71 años de edad, con un cuadro de 2 años de evolución de temblor de ambas extremidades superiores, lo cual le sucede al escribir, tomar un objeto, o al usar cubiertos. Toma alprazolam 0,5 mg/dl, dos veces por día por cuadro ansioso. Al examen físico no tiene temblor de reposo y se observan reflejos osteotendíneos conservados, con tono muscular y sensibilidad normal. El temblor se acentúa al tratar de tomar un objeto. **El diagnóstico más probable es:**

A Hipertiroidismo
B Enfermedad de Parkinson
C Temblor esencial
D Temblor por ansiedad
E Temblor por medicamentos

Respuesta C. Temblor bilateral de acción de 2 años (al escribir, tomar objetos, usar cubiertos), sin temblor de reposo y con tono normal: temblor esencial. El alprazolam no causa temblor; más bien lo atenúa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 85

Un paciente de 72 años consulta por temblor ambas extremidades, que aparece al realizar sus actividades habituales. Al examen físico se observa el mencionado temblor, sin otras alteraciones en la exploración neurológica. **¿Cuál es el fármaco más adecuado para el manejo de sus síntomas?**

A Diazepam
B Alprazolam
C Propranolol
D Levodopa
E Sertralina

Respuesta C. Temblor de acción bilateral con examen neurológico por lo demás normal: temblor esencial. El tratamiento de primera línea es propranolol (o primidona).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 147

Adulto mayor con temblor al escribir, un temblor esencial ¿Con que se trata? a. Propanolol

A Accidente cerebrovascular
B Epilepsia
C Esclerosis múltiple
D Enfermedad de Parkinson
E Migraña

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Accidente cerebrovascular).

▶ VER CLASE 1.10.1.027 Trastornos del sueño

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.11 · Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras

QUÉ HAY QUE SABER

- Insomnio: el trastorno del sueño más frecuente; primero higiene del sueño y terapia cognitivo-conductual; buscar depresión, ansiedad, dolor, alcohol y cafeína. Benzodiacepinas solo por períodos cortos.
- Apnea obstructiva del sueño: ronquido, apneas presenciadas, somnolencia diurna, obesidad, HTA resistente; se estudia con polisomnografía y se trata con CPAP y baja de peso.
- Trastorno conductual del sueño REM: grita, golpea o patea actuando sus sueños (pérdida de la atonía del REM); se asocia a sinucleinopatías (Parkinson, Lewy) y puede precederlas por años.
- Parasomnias no REM (sonambulismo, terrores nocturnos): niños, sin recuerdo, benignas.
- Narcolepsia: somnolencia diurna excesiva con cataplejía, alucinaciones hipnagógicas y parálisis del sueño. Piernas inquietas: medir ferritina.
- Manejo inicial: medidas de higiene y tratar comorbilidades; derivar a neurología o centro de sueño para polisomnografía.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 98

Hombre de 65 años con antecedente de enfermedad de Parkinson. Su pareja refiere que durante el sueño emite gritos, golpea y patea. El paciente no recuerda nada al despertar. **¿Cuál es el diagnóstico?**

A Trastorno de conducta del sueño REM (RBD)

B Sonambulismo

C Terrores nocturnos

D Apnea obstructiva del sueño

E Epilepsia nocturna del lóbulo frontal

Respuesta A. Conducta violenta durante el sueño en un paciente con Parkinson: trastorno conductual del sueño REM. Se pierde la atonía del REM y el paciente actúa sus sueños. Es la parasomnia típica de las sinucleinopatías.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 122

Un paciente, durante el sueño, se levanta, grita y golpea. Al despertar refiere que soñaba que se defendía. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Sonambulismo

B Terror nocturno (pavor nocturnus)

C Trastorno conductual del sueño REM

D Pesadillas recurrentes

E Epilepsia nocturna del lóbulo frontal

Respuesta C. Conductas motoras violentas que representan el contenido de un sueño, con recuerdo onírico al despertar, son típicas del trastorno conductual del sueño REM, por pérdida de la atonía muscular propia de esa fase. Se asocia a sinucleinopatías como Parkinson y cuerpos de Lewy, y puede precederlas por años. Sonambulismo y terrores nocturnos ocurren en sueño no REM, sin recuerdo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 84

Un paciente de 75 años ha presentado varios episodios durante el sueño, en los que tiene movimientos bruscos, actuando sus sueños, llegando incluso a golpear a su a su esposa en una oportunidad, mientras dormía. Cuando despertó comentó que estaba soñando que lo atacaban, por lo que se estaba defendiendo. Se muestra muy preocupado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Sonambulismo

B Epilepsia de lóbulo frontal

C Enfermedad de Parkinson

D Trastorno conductual del sueño REM

E Síndrome confusional agudo

Respuesta E. Diagnóstico: Síndrome confusional agudo (opción E). Esta clase cubre los principales trastornos del sueño: insomnio, hipersomnia, síndrome de piernas inquietas, pesadillas y terrores nocturnos, y narcolepsia.

▶ VER CLASE **1.10.1.028** **Tumores de región sellar**

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.20 · Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Masas selares: adenomas hipofisarios (prolactinoma 40%, no funcionante 30–35%), craneofaringioma (quístico, calcificado; niños y >50 años), meningioma, quiste de Rathke, apoplejía.
- Macroadenoma (≥10 mm) con extensión supraselar comprime el quiasma: hemianopsia bitemporal con visión central conservada y cefalea; invasión del seno cavernoso: III, IV, VI par.
- Clínica hormonal: hiperprolactinemia (amenorrea, galactorrea, disfunción sexual), acromegalia, Cushing, o hipopituitarismo.
- Estudio triple: RM de silla turca con gadolinio, campimetría y perfil hormonal completo (prolactina, IGF-1, cortisol/ACTH, TSH/T4L, FSH/LH).
- Prolactinoma: cabergolina aunque haya hemianopsia (no cirugía). Macroadenoma no funcionante compresivo, GH o ACTH: cirugía transesfenoidal.
- Apoplejía hipofisaria (cefalea en trueno, pérdida visual, III par): hidrocortisona 100 mg EV inmediata y RM urgente. Seguimiento: derivar a endocrinología y neurocirugía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 80

Una mujer de 55 años consulta por cefalea progresiva, de localización interciliar y occipital, asociada a alteraciones visuales. Al examen físico, tiene hemianopsia heterónima, sin alteraciones motoras ni de la sensibilidad. **¿En qué estructura anatómica se encuentra con mayor probabilidad la lesión?**

A En las retinas

B En ambos nervios ópticos

C En el lóbulo occipital

D En la radiación óptica

E En el quiasma óptimo

Respuesta E. Hemianopsia heterónima (bitemporal): lesión del quiasma óptico, típicamente por un tumor hipofisario. El nervio óptico da amaurosis de un ojo; el lóbulo occipital, la radiación y la cintilla dan hemianopsia homónima contralateral.

▶ VER CLASE `1.10.1.029` **Tumores primarios y metastásicos SNC** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.2 · Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumores del SNC: metástasis son los más frecuentes en adultos (pulmón, mama, melanoma, riñón, colon); primarios: glioblastoma, meningioma; en niños, fosa posterior (meduloblastoma, astrocitoma pilocítico).
- Sospechar ante cefalea progresiva matinal con vómitos (hipertensión endocraneana), crisis de inicio tardío o focales, déficit focal progresivo o cambio cognitivo-conductual.
- Estudio: TAC o RM con contraste (lesión con realce en anillo y edema); en cáncer pulmonar la etapificación incluye RM de cerebro.
- Manejo inicial: dexametasona para el edema vasogénico, antiepiléptico solo si hubo crisis, control de la hipertensión endocraneana; no hacer punción lumbar antes de la imagen.
- Diferencial de lesión en anillo: absceso cerebral (fiebre, foco ótico o sinusal) y neurocisticercosis.
- Seguimiento: derivar a neurocirugía y oncología (cirugía, radioterapia; en microcítico, irradiación holocraneal profiláctica).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 61 años, fumador, con adenocarcinoma pulmonar recién diagnosticado, consulta por cefalea matinal progresiva, vómitos y paresia leve de la mano derecha. La resonancia cerebral muestra 3 lesiones redondeadas con realce en anillo en la unión córtico-subcortical, rodeadas de extenso edema vasogénico. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado de los síntomas?**

A Dexametasona

B Manitol en infusión continua por 2 semanas

C Antibióticos por absceso cerebral

D Anticoagulación

E Punción lumbar evacuadora

Respuesta A. Lesiones múltiples con realce en anillo en la unión córtico-subcortical, en un paciente con cáncer pulmonar, corresponden a metástasis cerebrales, los tumores intracraneales más frecuentes del adulto. Los síntomas por edema vasogénico se tratan con dexametasona; luego se define radiocirugía, radioterapia o cirugía. La punción lumbar está contraindicada por el efecto de masa.

Situaciones clínicas de urgencia

21 códigos

▶ VER CLASE `1.10.2.001` **Cefalea aguda en urgencia** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.4 · Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino
Neurología 10.6 · Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

QUÉ HAY QUE SABER

- Primero buscar banderas rojas (SNOOP10): síntomas sistémicos, focalidad o compromiso de conciencia, inicio en trueno, >50 años, cambio de patrón, empeora con Valsalva o decúbito, papiledema.
- Cefalea en trueno: TAC sin contraste inmediato; si es normal, punción lumbar a las 6–12 h buscando xantocromía (hemorragia subaracnoidea).
- Fiebre con meningismo: hemocultivos, dexametasona y antibióticos antes de la imagen (meningitis). Cefalea nueva en >50 años: VHS y PCR (arteritis de la temporal).
- Mujer joven con anticonceptivos o puerperio y cefalea progresiva con signos de HTEC: trombosis venosa cerebral (angio-RM venosa; TAC normal no descarta).
- Crisis migrañosa típica sin banderas rojas: no requiere imagen; hidratación, ketorolaco EV y metoclopramida EV (sumatriptán SC alternativa); evitar opioides.
- Seguimiento: derivar según la causa secundaria; las primarias se controlan en APS.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 34 años consulta en urgencia por cefalea holocránea de 10 días, progresiva, que empeora al toser y al acostarse, con vómitos matinales. Usa anticonceptivos orales. Afebril, PA 124/78 mmHg, sin rigidez de nuca ni déficit motor. **¿Cuál de los siguientes hallazgos es una bandera roja que obliga a neuroimagen urgente?**

A Fotofobia y náuseas

B Antecedente familiar de migraña

C Edema de papila bilateral en el fondo de ojo

D Dolor opresivo bilateral

E Alivio parcial con paracetamol

Respuesta C. Una cefalea nueva o progresiva con banderas rojas (SNOOP: síntomas sistémicos, signos neurológicos como edema de papila, inicio súbito, inicio después de los 50 años, cambio de patrón o empeoramiento con Valsalva y decúbito) obliga a neuroimagen. El edema de papila indica hipertensión endocraneana. Fotofobia, náuseas y dolor opresivo son propios de cefaleas primarias.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 30 años con migraña sin aura diagnosticada hace 8 años consulta en urgencia por una crisis igual a las habituales, de 10 horas de evolución, hemicránea pulsátil con fotofobia y vómitos repetidos que le impiden tomar medicamentos orales. Afebril, PA 118/74 mmHg, examen neurológico normal, sin rigidez de nuca. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A TAC de encéfalo urgente antes de tratar

B Morfina EV

C Punción lumbar

D Hidratación EV, ketorolaco EV y metoclopramida EV, sin neuroimagen

E Sumatriptán oral y alta inmediata

Respuesta D. Crisis migrañosa típica, igual a las previas y sin banderas rojas: no requiere imagen. Con vómitos se usa la vía parenteral: AINE EV (ketorolaco) más antiemético antidopaminérgico (metoclopramida), con hidratación; el sumatriptán subcutáneo es alternativa. Los opioides se evitan por cefalea de rebote y recurrencia; la vía oral fallará con vómitos.

▶ VER CLASE 1.10.2.002 Complicaciones neurológicas de abuso de sustancias

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.16 · Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

QUÉ HAY QUE SABER

- Cocaína y pasta base: toxíndrome simpaticomimético (midriasis, taquicardia, HTA, hipertermia, agitación, psicosis paranoide); complicaciones neurológicas: ACV isquémico o hemorrágico, convulsiones, hemorragia subaracnoidea.
- Manejo: benzodiacepinas EV (diazepam 5–10 mg o lorazepam 2–4 mg) para agitación, HTA y convulsiones; nunca betabloqueadores puros (alfa sin oposición).
- Benzodiacepinas: sopor, ataxia, disartria y nistagmo con signos vitales estables; soporte ventilatorio. Flumazenil contraindicado en usuarios crónicos o coingesta de tricíclicos (status epiléptico).
- Opioides: miosis puntiforme, bradipnea y coma; naloxona EV.
- Alcohol: abstinencia con convulsiones (12–48 h, tratar con benzodiacepinas, no fenitoína), delirium tremens y encefalopatía de Wernicke (tiamina antes de la glucosa).
- Seguimiento: derivar a programa de adicciones tras estabilizar; entrevista motivacional según la etapa de cambio.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 29 años es traído a urgencia 1 hora después de consumir cocaína por cefalea súbita intensa y hemiparesia izquierda. PA 210/120 mmHg. **¿Cuál es el examen más importante a realizar de inmediato?**

A Electroencefalograma

B Punción lumbar

C TAC de cerebro sin contraste

D Toxicológico en orina como único examen

E Ecocardiograma

Respuesta C. La cocaína produce vasoconstricción, crisis hipertensivas y vasculitis, causando ACV isquémico, hemorragia intracerebral y subaracnoidea en jóvenes, además de convulsiones. Ante un déficit focal agudo se realiza de inmediato una TAC de cerebro sin contraste para distinguir hemorragia de isquemia. La agitación y la hipertensión se manejan con benzodiacepinas, evitando betabloqueadores.

▶ VER CLASE 1.10.2.003 Crisis convulsiva

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.9 · Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo
Neurología 10.10 · Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Crisis convulsiva activa: proteger de lesiones, posición lateral, ABC, oxígeno y glicemia capilar; no introducir objetos en la boca.

- La mayoría se autolimita antes de 2 minutos; si dura ≥5 minutos o hay crisis repetidas sin recuperar conciencia es estatus: benzodiacepina inmediata (lorazepam 4 mg EV o midazolam 10 mg IM).
- Diferenciar del síncope convulsivo (pródromos, mioclonías <15 s, recuperación lúcida) y de crisis psicógenas (movimientos asincrónicos, ojos cerrados con fuerza).
- Buscar causa provocada: hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, abstinencia alcohólica, tóxicos, infección del SNC, TEC, ACV; en embarazada con HTA, eclampsia (sulfato de magnesio).
- Estudio de primera crisis: electrolitos, función renal y hepática, ECG, TAC en urgencia y luego RM y EEG.
- Seguimiento: derivar a neurología; no conducir por 6–12 meses.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 166

Mujer de 17 años presenta súbitamente desviación de la cabeza hacia la derecha y cae al suelo. Su madre presenció el hecho y observó que mantuvo la mirada conjugada hacia la derecha, tras lo cual presentó hipertonía de todo el cuerpo, seguida de movimientos rítmicos de las 4 extremidades. Se recupera somnolienta y adolorida, con signos de haberse mordido la lengua, con impresión de la arcada dentaria en la zona lateral de la lengua. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Crisis convulsiva primariamente generalizada

B Crisis focal secundariamente generalizada

C Síncope vasovagal

D Trastorno conversivo

E Trastorno facticio

Respuesta B. La desviación versiva inicial de la cabeza y la mirada indica un inicio focal (frontal, contralateral a la desviación), seguido de fases tónica y clónica generalizadas, con mordedura lateral de lengua y estado postictal: crisis focal con evolución a bilateral tónico-clónica. Ese inicio focal descarta que sea primariamente generalizada y obliga a buscar una lesión estructural.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 22 años, sana, de pie en una fila bancaria calurosa y concurrida, refiere mareo intenso, visión borrosa y náuseas; se pone pálida y sudorosa y cae al suelo, inconsciente por unos 20 segundos. Una testigo describe sacudidas breves y aisladas de ambos brazos por unos 5 segundos. A los 2 minutos está despierta, orientada y recuerda los síntomas previos. Sin incontinencia ni mordedura de lengua. Examen físico y neurológico normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar levetiracetam y solicitar EEG ambulatorio

B Solicitar resonancia magnética de cerebro y EEG antes de decidir

C Explicar el diagnóstico de síncope vasovagal y educar en maniobras de contrapresión

D Iniciar ácido valproico por tratarse de una crisis generalizada

E Hospitalizar para video-EEG

Respuesta C. Síncope vasovagal con mioclonías anóxicas (síncope convulsivo): gatillante claro, pródromos autonómicos, inconsciencia breve, sacudidas de menos de 15 s tras el colapso, sin mordedura lateral ni incontinencia, y recuperación inmediata y lúcida. No es una crisis epiléptica: no requiere EEG ni antiepilépticos; se educa en maniobras de contrapresión y medidas higiénico-dietéticas.

▶ VER CLASE 1.10.2.004 Estado confusional agudo (alcohólico, tóxico metabólico)

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.21 · Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente
Psiquiatría 17.15 · Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

QUÉ HAY QUE SABER

- Delirium (CAM): inicio agudo y fluctuante + inatención (MUNDO al revés), más pensamiento desorganizado o conciencia alterada. El hipoactivo es el más frecuente y grave.
- Buscar siempre la causa (I WATCH DEATH): infección urinaria o neumonía, metabólica, hipoxia, fármacos anticolinérgicos, benzodiacepinas u opioides; globo vesical y fecaloma.
- Abstinencia alcohólica: temblor (6–12 h), alucinosis lúcida (12–24 h), convulsiones (12–48 h) y delirium tremens (48–96 h: confusión, disautonomía, fiebre, zoopsias; mortalidad 5–15%).
- Delirium tremens: diazepam 10–20 mg según CIWA-Ar (lorazepam si cirrosis), hospitalizar (UPC si grave); tiamina 100–300 mg EV antes de cualquier glucosado (Wernicke: oftalmoplejía, ataxia, confusión).
- Delirium común: medidas no farmacológicas (reorientar, lentes, audífonos, sueño, sin sujeción); haloperidol 0,5–1 mg solo si hay riesgo; quetiapina en Parkinson o Lewy; benzodiacepinas contraindicadas fuera de la abstinencia.
- Seguimiento completo: control hasta resolución y de la causa; tras abstinencia, intervención motivacional y naltrexona o disulfiram en programa de alcohol.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 52 años, bebedor de 1 litro de destilado al día, desnutrido, es traído a urgencia por 2 días de confusión e inestabilidad. Desorientado, apático, con nistagmo horizontal, paresia bilateral del recto lateral y ataxia de marcha que le impide caminar sin ayuda. Afebril, PA 128/80 mmHg, glicemia 94 mg/dL, sin signos de abstinencia. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Suero glucosado al 30 % EV en bolo

B Haloperidol 5 mg IM

C Tiamina EV en dosis altas, antes o junto con cualquier aporte de glucosa

D Lorazepam EV como única medida

E Punción lumbar urgente

Respuesta C. Confusión, oftalmoplejía y ataxia en un alcohólico desnutrido: encefalopatía de Wernicke por déficit de tiamina, una emergencia que basta sospechar. Se administra tiamina EV en dosis altas (por ejemplo, 500 mg cada 8 horas) antes o junto con la glucosa, ya que la glucosa sin tiamina puede precipitar o agravar el cuadro y evolucionar a síndrome de Korsakoff.

▶ VER CLASE 1.10.2.005 Distonía aguda por fármacos (ejemplo antieméticos)

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.13 · Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Distonía aguda: contracción muscular sostenida y dolorosa minutos a 48 h tras un bloqueador D2 (metoclopramida, haloperidol, antipsicóticos); más en jóvenes y niños.
- Formas: crisis oculógira (mirada fija hacia arriba), tortícolis, protrusión lingual, trismus, opistótonos; conciencia conservada, afebril.
- Tratamiento: biperideno 2,5–5 mg IM o EV lento (alivio en 10–15 min); alternativa difenhidramina EV; luego biperideno oral 2 mg c/8–12 h por 24–48 h.
- Suspender el fármaco causal; la domperidona casi no cruza la barrera hematoencefálica. No requiere TAC ni anticonvulsivantes.
- Diferencial: síndrome neuroléptico maligno (fiebre, rigidez generalizada, compromiso de conciencia, CK alta) y crisis epiléptica.
- No requiere seguimiento: educar sobre el fármaco causal y registrarlo como reacción adversa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 23 años, sin antecedentes, consulta en urgencia por náuseas y dolor cólico epigástrico tras una comida grasa. Recibe analgesia y metoclopramida 10 mg EV. A los 40 minutos presenta ojos desviados de forma fija hacia arriba, contractura cervical dolorosa con rotación del mentón hacia la izquierda y protrusión de la lengua con dificultad para hablar. Está angustiada. PA 125/75 mmHg, FC 82 lpm, afebril, Glasgow 15, pupilas isocóricas reactivas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Diazepam 10 mg EV y TAC de cerebro

B Biperideno 2,5 a 5 mg IM o EV lento

C Haloperidol 5 mg IM

D Propranolol 40 mg oral

E Levodopa/carbidopa oral

Respuesta B. Crisis oculógira, tortícolis y distonía lingual 40 minutos después de metoclopramida EV: distonía aguda por fármacos. El tratamiento es un anticolinérgico central (biperideno IM o EV lento), con alivio en 10–15 minutos y mantención oral por 24–48 horas. No es una crisis epiléptica ni requiere TAC; el haloperidol la empeoraría.

▶ VER CLASE 1.10.2.006 Encefalopatías tóxico metabólicas (urémica, hepática, etc)

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.3 · Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Encefalopatía tóxico-metabólica: compromiso de conciencia difuso y fluctuante, sin focalidad, con asterixis, mioclonías y a veces convulsiones; pupilas reactivas.
- Hepática: cirrótico con desorientación y asterixis; buscar precipitante (infección, HDA, constipación, sedantes, diuréticos, hipokalemia). Tratar el precipitante + lactulosa (2–3 deposiciones blandas al día) ± rifaximina.
- Urémica: letargia, asterixis, mioclonías, convulsiones; con pericarditis o encefalopatía es indicación de hemodiálisis urgente.
- Otras: hipoglicemia, hiponatremia o hipernatremia, hipercalcemia, hipercapnia, sepsis, hipotiroidismo, fármacos y Wernicke (tiamina EV).
- Manejo inicial: glicemia capilar, electrolitos, gases, amonio, función renal y hepática, tóxicos; TAC si hay focalidad o trauma; proteger la vía aérea si Glasgow ≤8.
- Seguimiento: derivar según la causa (gastroenterología, nefrología, UPC).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 63 años con cirrosis alcohólica, abstinente, es traído por somnolencia y desorientación de 2 días. Al examen tiene asterixis, sin fiebre ni dolor abdominal, y refiere constipación de 5 días. Glicemia y electrolitos normales. La paracentesis no muestra signos de infección. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Flumazenil

B Restricción proteica absoluta

C Benzodiacepinas para la agitación

D Lactulosa oral para lograr 2 a 3 deposiciones blandas al día

E Furosemida endovenosa

Respuesta D. Un compromiso de conciencia con asterixis en un cirrótico es una encefalopatía hepática, aquí precipitada por constipación. Se buscan y corrigen los precipitantes (infección, hemorragia, diuréticos, alteraciones electrolíticas) y se indica lactulosa para lograr 2 a 3 deposiciones blandas al día, agregando rifaximina si recurre. La restricción proteica ya no se recomienda y las benzodiacepinas la empeoran.

▶ VER CLASE 1.10.2.007

Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.1 · Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES
Neurología 10.2 · Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria
Neurología 10.3 · Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos
Neurología 10.5 · Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena

QUÉ HAY QUE SABER

- Déficit focal súbito (Cincinnati: cara, brazo, habla): código ACV; anotar la hora de inicio o última vez visto bien; glicemia capilar; TAC sin contraste informado en ≤30 min para descartar sangre.
- Isquémico ≤4,5 h sin sangre: trombolisis (alteplase 0,9 mg/kg, máx 90 mg, o tenecteplase 0,25 mg/kg) con PA <185/110; oclusión de gran vaso: trombectomía hasta 6 h (6–24 h con mismatch).
- No trombolizado: hipertensión permisiva hasta 220/120, AAS 250 mg, atorvastatina 80 mg, glicemia 70–180, normotermia; trombolizado: AAS a las 24 h tras TAC de control.
- Hemorrágico: PAS 130–140 con labetalol o nicardipino EV; revertir anticoagulación (acenocumarol: CCP + vitamina K; dabigatrán: idarucizumab); cerebeloso ≥3 cm se opera.
- AIT (déficit resuelto sin infarto en la imagen): ABCD² ≥4 o FA, crescendo o estenosis = hospitalizar; estudio en <48 h; AAS + clopidogrel 21 días si no es cardioembólico; FA: anticoagular; estenosis 70–99%: endarterectomía en <2 semanas.
- GES: atención en UTAC; derivar a neurología y rehabilitación. Infarto lacunar: hemiparesia pura sin afasia ni hemianopsia.

PREGUNTAS · 12

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 93

Un paciente de 67 años presenta hemiparesia derecha de dos horas de evolución, que inició de manera súbita y se asocia a dificultades para hablar. Al examen físico tiene hemiparesia faciobraquiocrural derecha y afasia. Su TAC de cerebro es normal. **La conducta más adecuada es:**

A Anticoagular con heparina

B Administrar antiagregantes plaquetarios

C Solicitar resonancia magnética nuclear

D Realizar embolectomía

E Realizar trombólisis

Respuesta E. Déficit focal súbito de 2 horas con TAC normal: el TAC descarta hemorragia y confirma un infarto isquémico en ventana (< 4,5 h). Lo más urgente es la trombolisis EV.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 121

Paciente con cefalea súbita y hemiplejia del hemicuerpo izquierdo, sin alteraciones sensitivas ni del habla. **¿Diagnóstico más probable?**

A Hemorragia intracerebral en cápsula interna

B AVE isquémico de territorio carotídeo

C Hematoma subdural agudo

D AVE isquémico de territorio basilar

E Infarto lacunar

Respuesta E. Hemiplejia pura, sin compromiso sensitivo ni del lenguaje: síndrome lacunar motor puro (brazo posterior de la cápsula interna). La ausencia de afasia, hemianopsia y negligencia indica que no hay compromiso cortical.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 76

Un paciente de 32 años presenta dolor cervical intenso, mientras realizaba deporte, que se irradia hacia la cara, zona temporal y se asocia a cefalea intensa. Al examen físico se observa ptosis y miosis derechas. **El diagnóstico más probable es:**

A Parálisis del tercer nervio craneal
B Aneurisma cerebral anterior, con compromiso del tercer nervio craneal
C Infarto vertebrobasilar
D Migraña hemipléjica
E Disección carotidea

Respuesta E. Adulto joven con dolor cervical y cefalea tras esfuerzo o elongación: disección arterial (TOAST: otra etiología determinada). La ptosis con miosis es un síndrome de Horner por compromiso simpático a nivel de la carótida.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 1

Una paciente de 40 años, usuaria de anticonceptivos orales, consulta por cefalea holocránea, muy intensa, de 5 días de evolución, que se ha asociado a náuseas y vómitos alimentarios, mayores en la mañana, y que no ha respondido al uso de analgésicos orales. Hoy presentó una convulsión tónico-clónica. En su examen físico tiene sopor superficial paresia de las extremidades derechas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Migraña por anticonceptivos
B Infarto cerebral extenso
C Accidente vascular lacunar
D Epilepsia con parálisis de Todd
E Trombosis venosa cerebral

Respuesta E. Cefalea progresiva de días con vómitos matinales (signos de hipertensión endocraneana), convulsión y déficit focal en usuaria de anticonceptivos orales: trombosis venosa cerebral, una de las causas de "otra etiología determinada" en TOAST.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 26

Un paciente de 60 años, con hipertensión arterial de larga data mal controlada, consulta por cefalea intensa que ha aumentado en intensidad hasta EVA 9/10, asociada a vómitos y mareos de 2 horas de evolución, por lo que acude al servicio de urgencias. Al examen físico presenta presión arterial 170/105 mmHg y frecuencia cardíaca 62 lpm, sin signos focales en el examen neurológico. Se solicita una TAC de cerebro que se muestra a continuación: **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hematoma subdural
B Hemorragia subaracnoidea
C Infarto de arteria cerebral media con transformación hemorrágica
D Hematoma talámico derecho
E Hemorragia intraparenquimatosa secundaria a malformación arteriovenosa

Respuesta D. La TAC original mostraba una hiperdensidad (sangre) intraparenquimatosa en el tálamo. Hipertenso crónico mal controlado con cefalea y vómitos: hemorragia hipertensiva en un núcleo profundo. Contraindica antiagregantes, anticoagulación y trombólisis; la meta es una PAS cercana a 140 mmHg. La MAV se piensa en el joven o no hipertenso.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 67 años, hipertenso. Hace 90 minutos presentó en forma súbita afasia y hemiparesia derecha braquiocrural (NIHSS 13). PA 205/115 mmHg, glicemia 118 mg/dL. El TAC de encéfalo sin contraste, informado a los 25 minutos del ingreso, es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar alteplase 0,9 mg/kg de inmediato
B Labetalol EV hasta PA < 185/110 mmHg y luego trombolisis
C No tratar la presión: hipertensión permisiva hasta 220/120 mmHg
D AAS 250 mg y hospitalizar en UTAC
E Solicitar resonancia magnética antes de decidir

Respuesta B. Infarto de la ACM izquierda en ventana (< 4,5 h), TAC sin sangre: candidato a trombolisis. La PA debe estar < 185/110 mmHg antes de iniciar el trombolítico: se baja con labetalol o nicardipino EV y luego se tromboliza. La hipertensión permisiva hasta 220/120 es para el paciente no trombolizado.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 64 años, hipertenso y fumador, no diabético. Hace 2 horas presentó debilidad súbita de mano y pierna derechas con dificultad para articular palabras, que se resolvió por completo en unos 45 minutos. PA 155/95 mmHg, FC 80 lpm regular. Examen neurológico normal. TAC de encéfalo sin contraste sin sangrado ni lesiones isquémicas recientes. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Alta con AAS 100 mg y control con neurólogo en 1 mes
B Trombolisis intravenosa con alteplase
C Hospitalizar, estudio etiológico y AAS + clopidogrel por 21 días
D Hospitalizar e iniciar anticoagulación oral
E Hospitalizar y AAS + clopidogrel de forma indefinida

Respuesta C. AIT carotídeo izquierdo. ABCD² = 5 (edad ≥ 60: 1; PA ≥ 140/90: 1; debilidad unilateral: 2; duración 10–59 min: 1): riesgo moderado, se hospitaliza. Se completa el estudio (Doppler carotídeo, monitoreo cardíaco, resonancia) y se inicia AAS + clopidogrel por exactamente 21 días, más atorvastatina 80 mg.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 62 años con fibrilación auricular en tratamiento con acenocumarol e HTA mal controlada. Presenta cefalea súbita, vómitos explosivos y hemiplejia izquierda. PA 205/115 mmHg, Glasgow 11, desviación conjugada de la mirada hacia la derecha. TAC sin contraste: hematoma de 32 mL en el putamen derecho con invasión ventricular. INR 3,4. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Plasma fresco congelado y vitamina K oral; control de PA si supera 220 mmHg

B Complejo protrombínico de 4 factores + vitamina K EV y labetalol EV hasta PAS 130–140 mmHg

C Evacuación quirúrgica abierta del hematoma putaminal

D Nitroprusiato EV hasta PAS menor de 120 mmHg y suspender el acenocumarol

E Idarucizumab 5 g EV y nicardipino EV

Respuesta B. Hemorragia putaminal hipertensiva agravada por acenocumarol (INR 3,4). Dos medidas simultáneas en minutos: CCP 4F (25–50 UI/kg) + vitamina K1 10 mg EV, y labetalol o nicardipino EV a PAS 130–140 mmHg sin bajar de 130. Ingreso a UCI con evaluación neuroquirúrgica. La evacuación abierta del putamen no está indicada de rutina (STICH). El idarucizumab revierte dabigatrán, no acenocumarol.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 29 años, en su 4° día de puerperio, usuaria de anticonceptivos orales combinados hasta el embarazo. Consulta por 4 días de cefalea holocránea progresiva que empeora al acostarse y al toser, con vómitos matinales. En las últimas 12 horas presentó 3 crisis focales del brazo derecho con generalización. Somnolienta, con papiledema bilateral y leve paresia braquial derecha. TAC sin contraste: lesión hipodensa temporoparietal izquierda con focos hiperdensos petequiales, que no respeta un territorio arterial. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Evitar la anticoagulación por la transformación hemorrágica e iniciar levetiracetam

B Trombolisis intravenosa con alteplase

C Enoxaparina 1 mg/kg cada 12 horas SC, levetiracetam EV e ingreso a UPC

D Punción lumbar evacuadora y acetazolamida

E Aspirina 300 mg y control con resonancia en 48 horas

Respuesta C. Trombosis venosa cerebral con infarto venoso hemorrágico en una puérpera usuaria de ACO: cefalea progresiva con signos de HTEC, convulsiones y lesión que no respeta territorios arteriales. La hemorragia se debe a la hipertensión venosa retrógrada: se anticoagula igual, con HBPM en dosis plena. Como hubo crisis, se agrega levetiracetam. Se confirma con Angio-RM venosa o AngioTAC venosa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 66

Paciente de 72 años llega a urgencias con hemiparesia derecha y afasia de inicio súbito hace 5 horas. TAC de cerebro sin contraste: normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Antiagregación plaquetaria (aspirina 250 mg) e hospitalización

B Trombolizar con rtPA (ya pasaron >4.5h, fuera de ventana)

C Trombectomía mecánica (evaluar si hay oclusión de gran vaso)

D Observación domiciliaria

E Anticoagulación con heparina inmediata

Respuesta A. ACV isquémico a las 5 horas: fuera de ventana para trombolisis (>4.5h). Si no hay oclusión de gran vaso, el tratamiento es antiagregación (aspirina) + hospitalización para monitoreo y estudios etiológicos. Anticoagulación no está indicada en ACV isquémico agudo de forma rutinaria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 119

Una paciente de 24 refiere que luego de realizar ejercicios de elongación, presenta dolor súbito en el cuello y en la cabeza, con cefalea en trueno (thunderclap). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Cefalea cluster o en racimo

B Accidente isquémico transitorio

C Disección de la arteria cerebral o carótida

D Migraña sin aura desencadenada por el ejercicio.

E Hernia traumática del núcleo pulposo

Respuesta C. Diagnóstico: Disección de la arteria cerebral o carótida (opción C). La disección era la única opción posible. Sigue siendo un cuadro raro. La combinación cardinal de dolor torácico súbito desgarrador (EVA 10/10) irradiado a región interescapular o dorso, cifras tensionales severas y asimetría de pulsos periféricos en extremidades superiores es patognomónica de disección aórtica aguda. Requiere angio-TAC de tórax inmediato y estabilización hemodinámica con betabloqueadores EV para reducir la...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 97

Una paciente de 65 años, hipertenso y diabético de larga data, consulta por cefalea intensa de inicio súbito, asociado a dificultades para moverse. Al examen físico tiene una hemiparesia derecha, armónica, sin compromiso de conciencia y con conservación del lenguaje y la sensibilidad. No tiene alteraciones visuales. Como antecedente, ha sufrido golpes por caídas a repetición. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Accidente vascular encefálico por compromiso de la arteria cerebral media

B Accidente vascular encefálico por compromiso de la arteria cerebral anterior

C Hemorragia de la protuberancia anular o puente de Varolio

D Accidente vascular encefálico hemorrágico

E Accidente vascular de tipo lacunar

Respuesta A. Diagnóstico: Accidente vascular encefálico por compromiso de la arteria cerebral media (opción A).

▶ VER CLASE 1.10.2.008 **Hemorragia subaracnoídea** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.4 · Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino

QUÉ HAY QUE SABER

- Cefalea en trueno: máxima intensidad en <1 minuto, «la peor de mi vida», a menudo con esfuerzo o Valsalva; puede haber pérdida de conciencia inicial y vómitos.
- Signos meníngeos tardan 6–12 h: su ausencia no la descarta. Parálisis del III par con midriasis = aneurisma de comunicante posterior.
- TAC sin contraste inmediato (sensibilidad ~98–100% en <6 h); si es normal, punción lumbar a las 6–12 h: xantocromía y glóbulos rojos iguales en los 3 tubos.
- Confirmada: angioTAC o angiografía para buscar el aneurisma; asegurarlo con coils o clipaje en 24–72 h (el resangrado es lo más letal).
- Mientras: UPC, PAS <160 con labetalol o nicardipino, analgesia y antieméticos; nimodipino 60 mg c/4 h VO por 21 días; euvolemia; hiponatremia con suero fisiológico o hipertónico, nunca restricción hídrica.
- Complicaciones: vasoespasmo (días 4–14), hidrocefalia (drenaje ventricular) y alteraciones cardíacas. No requiere seguimiento del médico general: derivar a neurocirugía.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 136

Un paciente de 50 años, sin antecedentes, presenta cefalea de inicio súbito mientras hacía deporte, asociado a dolor en la zona cervical posterior y dorsal. Al examen físico presenta reflejo fotomotor conservado, signos meníngeos presentes, fuerza y sensibilidad disminuidas en hemicuerpo izquierdo. **El diagnóstico más probable es:**

A Hemorragia subaracnoídea

B Hematoma epidural

C Hematoma subdural

D Hemorragia cerebral intraparenquimatosa

E Accidente vascular isquémico

Respuesta A. Cefalea súbita durante el ejercicio, con dolor cervical y signos meníngeos: hemorragia subaracnoidea. Los signos focales no son lo típico, pero pueden aparecer. Sin trauma no se piensa en hematoma epidural ni subdural; la hemorragia intraparenquimatosa daría cefalea con déficit focal, y lo que domina aquí es lo meníngeo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 139

Un paciente de 54 años, alcohólico e hipertenso, hace una semana suspende todos los antihipertensivos. Es traído a la urgencia por cefalea muy intensa, de inicio agudo, asociado a desorientación y compromiso de conciencia. Al examen físico está soporoso, no habla ni sigue indicaciones, aunque mantiene movilidad espontánea de las 4 extremidades. Sus reflejos osteotendíneos y tono muscular son normales y tiene signo de Babinski bilateral. **El diagnóstico más probable es:**

A Hemorragia subaracnoidea

B Meningitis bacteriana

C Edema cerebral

D Intoxicación etílica

E Accidente vascular isquémico extenso

Respuesta A. Cefalea muy intensa de inicio agudo con compromiso de conciencia y sin déficit motor focal, en un hipertenso sin tratamiento: hemorragia subaracnoidea (el alza brusca de la PIC explica el compromiso de conciencia). No hay fiebre para meningitis, y un infarto extenso daría un déficit focal evidente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 178

Una paciente de 42 años, hipertensa, presenta cefalea intensa, que inició súbitamente hace 6 horas, mientras realizaba ejercicio y se ha acompañado de vómitos alimentarios. Al examen físico está vigil y orientada, adolorida, con FC: 70x', PA: 140/90 mmHg, en el examen neurológico tiene signos meníngeos presentes, sin alteraciones motoras ni sensitivas. Se solicita TAC de cerebro sin contraste, que muestra hiperdensidad del espacio intercomisural frontal y del espacio subaracnoideo basal. **¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?**

A Resonancia magnética nuclear de cerebro
B Punción lumbar
C TAC de cerebro con contraste
D Angiografía cerebral
E Ecocardiograma

Respuesta D. El TAC ya confirmó la hemorragia subaracnoidea (sangre en el espacio interhemisférico y en las cisternas basales). El paso siguiente es el estudio vascular para encontrar el aneurisma y planificar su exclusión: angiografía cerebral (o AngioTAC). La punción lumbar solo se indica si el TAC es normal.

▶ VER CLASE 1.10.2.009 Hipertensión endocraneana

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.12 · Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC
Neurología 10.3 · Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante cefalea progresiva matinal con vómitos, edema de papila bilateral, VI par, compromiso de conciencia progresivo o tras TEC grave.
- Herniación inminente: midriasis unilateral arreactiva, hemiparesia y tríada de Cushing (HTA, bradicardia, respiración irregular); la HTA es compensatoria y no se baja.
- Medidas inmediatas: cabecera a 30° con cuello alineado, vía aérea (intubar si Glasgow ≤8), normoxemia y normocapnia (hiperventilación solo breve como puente), normotermia, evitar hipotensión y sueros hipotónicos.
- Osmoterapia: manitol o suero hipertónico (este último si hay hipotensión); dexametasona solo en edema vasogénico por tumor o absceso.
- TAC sin contraste urgente; punción lumbar contraindicada antes de la imagen.
- Seguimiento: derivar de urgencia a neurocirugía (evacuación de hematoma, drenaje ventricular, monitoreo de PIC).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años con TEC grave y contusiones cerebrales, intubado. Evoluciona con presión arterial 190/100, frecuencia cardíaca 48, respiración irregular y midriasis derecha arreactiva. Se coordina con neurocirugía. **¿Cuál es la medida inicial más adecuada mientras tanto?**

A Administrar labetalol para normalizar la presión arterial
B Administrar atropina por la bradicardia
C Hiperventilar en forma prolongada hasta PaCO2 de 25
D Realizar punción lumbar para medir la presión
E Elevar la cabecera a 30 grados, asegurar oxigenación y normoventilación, y administrar manitol o suero hipertónico

Respuesta E. Hipertensión, bradicardia y respiración irregular son la tríada de Cushing, signo de hipertensión endocraneana con herniación inminente. Se trata con cabecera a 30 grados, oxigenación y normoventilación, y osmoterapia con manitol o suero hipertónico. La hipertensión es compensatoria y no se debe bajar; la punción lumbar está contraindicada.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 47 años con 3 semanas de cefalea progresiva de predominio matinal y vómitos. Hoy su familia lo encuentra somnoliento. Glasgow 10, pupila derecha de 5 mm hiporreactiva, hemiparesia izquierda. PA 186/94 mmHg, FC 52 lpm, respiración irregular. TAC de encéfalo: masa frontotemporal derecha con extenso edema vasogénico y desviación de la línea media de 9 mm. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Punción lumbar para medir la presión de apertura
B Cabecera a 30°, asegurar la vía aérea, manitol EV, dexametasona EV y evaluación neuroquirúrgica urgente
C Hiperventilación sostenida con meta de PaCO2 de 25 mmHg durante 48 horas
D Suero glucosado al 5 % para hidratación
E Nitroprusiato EV para llevar la PA sistólica bajo 100 mmHg

Respuesta B. Hipertensión endocraneana con signos de herniación (sopor, midriasis ipsilateral, tríada de Cushing) por un tumor con edema: cabecera a 30°, vía aérea segura, osmoterapia (manitol o suero hipertónico), dexametasona por el edema vasogénico y neurocirugía urgente. La punción lumbar puede precipitar herniación; los sueros hipotónicos y la hipotensión empeoran el daño.

▶ VER CLASE 1.10.2.010 Movimientos anormales inducidos por fármacos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.12 · Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus

QUÉ HAY QUE SABER

- Distonía aguda (minutos a 48 h tras metoclopramida o haloperidol): crisis oculógira, tortícolis, trismus; biperideno 2,5–5 mg IM o EV.
- Acatisia (días): inquietud motora subjetiva e incapacidad de quedarse quieto; reducir dosis, propranolol o benzodiacepina.

- Parkinsonismo farmacológico (semanas): bilateral y simétrico, subagudo, sin pródromos; fármacos: metoclopramida, levosulpirida, antipsicóticos, flunarizina y cinarizina. Suspender gradualmente; no dar levodopa; remite en semanas a meses.
- Disquinesia tardía (meses a años): movimientos orofaciales de masticación y lengua; suspender o cambiar a antipsicótico atípico (clozapina, quetiapina).
- Síndrome neuroléptico maligno: fiebre, rigidez generalizada, compromiso de conciencia, disautonomía y CK alta: suspender el fármaco y UCI. Síndrome serotoninérgico: clonus e hiperreflexia con ISRS.
- No requiere seguimiento especial: revisar siempre la receta y evitar el fármaco causal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 74 años, hipertensa, con síndrome vertiginoso recurrente. Hace 4 meses se mueve con extrema lentitud y le tiemblan las manos al tomar la taza. Usa losartán, hidroclorotiazida, flunarizina 10 mg/noche (hace 9 meses) y metoclopramida 10 mg c/8 h (hace 6 meses). Examen: hipomimia, bradicinesia y rigidez en rueda dentada bilaterales y simétricas, temblor postural fino de ambas manos, sin temblor de reposo. Sin parálisis de la mirada vertical ni caídas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar levodopa/carbidopa

B Suspender gradualmente flunarizina y metoclopramida y controlar

C Iniciar pramipexol

D Solicitar RM cerebral y derivar por sospecha de parálisis supranuclear progresiva

E Iniciar propranolol por temblor esencial

Respuesta B. Parkinsonismo subagudo, bilateral y simétrico, con temblor postural, en una paciente que usa dos bloqueadores dopaminérgicos: parkinsonismo inducido por fármacos. Se suspenden gradualmente ambos fármacos; la recuperación puede tardar semanas a meses. No hay banderas rojas de PSP.

▶ VER CLASE 1.10.2.011 Paraplejia aguda

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.22 · Síndrome de Lisis Tumoral (Cairo-Bishop), Hipercalcemia de Neoplasia y Compresión Medular

QUÉ HAY QUE SABER

- Paraplejia aguda: debilidad de ambas piernas de instalación aguda con nivel sensitivo en el tronco y trastorno esfinteriano (retención urinaria) = lesión medular hasta demostrar lo contrario.
- Compresión medular neoplásica (metástasis vertebral de mama, pulmón, próstata, mieloma): dolor raquídeo progresivo y nocturno que precede a la paraparesia; la retención urinaria es tardía.
- Ante la sola sospecha: dexametasona 16–24 mg EV y RM de columna completa urgente; luego radioterapia o cirugía descompresiva.
- Otras causas: trauma raquimedular, hematoma o absceso epidural (fiebre, punción o anticoagulación), mielitis transversa (esclerosis múltiple, posinfecciosa), infarto medular (disección aórtica), Guillain-Barré (arreflexia sin nivel sensitivo).
- Medidas: sonda vesical, prevención de úlceras por presión y de TVP; no movilizar sin inmovilización si hay trauma.
- No requiere seguimiento del médico general: derivar de urgencia a neurocirugía u oncología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 72 años con cáncer de próstata metastásico presenta dolor dorsal de 3 semanas que empeora en decúbito y, desde hace 24 horas, debilidad de ambas piernas, con nivel sensitivo en T10 y retención urinaria. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Aumentar opioides y control en 1 semana

B Radiografía de columna y control ambulatorio

C Punción lumbar

D Kinesioterapia motora

E Dexametasona endovenosa y resonancia magnética urgente de toda la columna

Respuesta E. Una paraplejia aguda con nivel sensitivo y alteración esfinteriana en un paciente oncológico es una compresión medular neoplásica, emergencia oncológica. Se inicia dexametasona de inmediato y se realiza una resonancia urgente de toda la columna para definir radioterapia o cirugía descompresiva. El pronóstico funcional depende del estado neurológico al iniciar el tratamiento.

▶ VER CLASE 1.10.2.012 Síndrome cuadraplégico agudo

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.16 · Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Tetraparesia (cuadriplejia) aguda: localizar entre médula cervical (nivel sensitivo, esfínteres, reflejos vivos tras la fase de shock), tronco, nervio periférico (Guillain-Barré) o placa/músculo.
- Guillain-Barré: debilidad flácida simétrica ascendente con arreflexia, 1–4 semanas tras infección (Campylobacter, virus); puede comprometer pares craneales (diplejía facial) y dar disautonomía.
- Lo que mata es la falla respiratoria silenciosa: monitorizar capacidad vital cada 4–6 h (regla 20/30/40) y conteo en una espiración; la saturación cae tarde.
- UCI e intubación electiva si CVF <15–20 mL/kg, compromiso bulbar o disautonomía grave; nunca succinilcolina (hiperkalemia): usar rocuronio.
- Otras causas: compresión medular cervical (RM urgente), hiperkalemia (dializado que omite sesión: ECG), parálisis periódica hipokalémica (reflejos presentes), miastenia, botulismo.

- No requiere seguimiento del médico general: hospitalizar en UPC o intermedio y derivar a neurología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 34 años con diarrea hace 2 semanas presenta debilidad progresiva de 4 días, que comenzó en las piernas y ahora compromete los brazos, con arreflexia generalizada y parestesias distales. Hoy refiere dificultad para respirar al acostarse. **¿Cuál es el parámetro más importante a monitorizar en forma seriada?**

A Capacidad vital forzada

B Creatinquinasa (CK)

C Saturación de oxígeno como único parámetro

D Velocidad de sedimentación

E Glicemia

Respuesta A. Una tetraparesia aguda arrefléctica tras una diarrea sugiere síndrome de Guillain-Barré. El riesgo vital es la insuficiencia respiratoria neuromuscular, por lo que se monitoriza en forma seriada la capacidad vital forzada: valores menores de 20 mL/kg indican necesidad de UCI e intubación. La saturación cae tardíamente. El tratamiento es inmunoglobulina endovenosa o plasmaféresis.

▶ VER CLASE 1.10.2.013 Síndrome cuadriparético fláccido (poliradiculoneurítis aguda, Guillain-Barré)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.16 · Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Guillain-Barré: tetraparesia flácida, simétrica y ascendente con arreflexia, nadir a las 2–4 semanas; dolor radicular frecuente; pares craneales en >50% (diplejía facial) y disautonomía.
- Antecedente de infección 1–4 semanas antes (Campylobacter, CMV, EBV, influenza). Variante Miller Fisher: ataxia, arreflexia y oftalmoplejía (anti-GQ1b).
- LCR: disociación albúmino-citológica (proteínas altas, <10 células), puede ser normal la primera semana; >50 células obliga a buscar otra causa. EMG con onda F prolongada.
- Monitorizar capacidad vital (regla 20/30/40): UCI e intubación electiva con rocuronio si cae; la saturación normal no tranquiliza.
- Inmunoterapia si la marcha está alterada o progresa: inmunoglobulina EV 0,4 g/kg/día por 5 días o plasmaféresis; no combinarlas; corticoides contraindicados.
- Soporte: enoxaparina profiláctica, kinesiterapia precoz, gabapentina o pregabalina para el dolor. No requiere seguimiento del médico general: derivar a neurología.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 23

Un paciente de 29 años consulta por un cuadro de 7 días, progresivo, de disminución de la fuerza muscular, tanto en las extremidades superiores, como en las inferiores, siendo mayor en las inferiores. Tiene el antecedente de haber sufrido una influenza hace 14 días. Al examen físico tiene arreflexia aquiliana bilateral, asociada a hiporreflexia rotuliana mayor a derecha, con paresia M4 en las extremidades superiores y M3 en las inferiores. **El diagnóstico más probable es:**

A Radiculopatía S1 derecho

B Polineuropatía desmielinizante aguda

C Meningitis viral

D Mielopatía por influenza

E Miositis viral

Respuesta B. Infección 2 semanas antes, debilidad progresiva de las cuatro extremidades de predominio en las piernas e hipo o arreflexia: síndrome de Guillain-Barré, polineuropatía desmielinizante aguda.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 85

Un paciente de 38 años consulta por paresia facial bilateral, de una semana de evolución, mayor a izquierda. Además, presenta paresia del sexto bervio craneal izquierdo. Al examen físico tiene disminución generalizada de las fuerzas de las extremidades, con arreflexia e hipotonía. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Polineuropatía

B Síndrome de Guillain Barré

C Miastenia gravis

D Esclerosis múltiple

E Infarto de troncoencéfalo

Respuesta B. Diplejía facial (el par craneal más comprometido en el Guillain-Barré), compromiso de otro par craneal y debilidad generalizada con arreflexia e hipotonía: síndrome de Guillain-Barré.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 165

Un paciente de 24 años, sin antecedentes, es traído porque desde que despertó en la mañana no puede movilizar sus cuatro extremidades, sin otros síntomas. Al examen físico se corrobora fuerza totalmente disminuida en todo su cuerpo, sensibilidad normal, reflejos osteotendíneos presentes y simétricos. **El diagnóstico más probable es:**

A Síndrome de Guillain Barré
B Miastenia Gravis
C Botulismo
D Lesión medular cervical
E Parálisis periódica hipokalémica

Respuesta E. Debilidad de las cuatro extremidades que aparece al despertar, con reflejos presentes: no es Guillain-Barré, porque este tiene reflejos abolidos. Por descarte, parálisis periódica hipokalémica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 86

Una mujer de 32 años consulta por debilidad progresiva en ambas piernas, que inició hace 5 días y ha avanzado a las extremidades superiores en las últimas 48 horas. Refiere sensación de hormigueo en manos y pies, pero sin alteración sensorial significativa. No presenta fiebre ni dolor. Hace dos semanas tuvo un cuadro de infección respiratoria con tos y congestión nasal. Al examen físico, destaca debilidad simétrica en las extremidades, arreflexia global y marcha inestable. No hay signos de afectación de los pares craneales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar resonancia magnética de columna
B Iniciar tratamiento con inmunoglobulina intravenosa
C Solicitar resonancia magnética de cerebro
D Administrar corticosteroides endovenosos
E Iniciar aciclovir endovenoso

Respuesta B. Guillain-Barré típico (infección previa, debilidad ascendente simétrica, arreflexia) con marcha alterada: indicación de inmunoterapia precoz con inmunoglobulina EV. Los corticoides están contraindicados.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 170

Paciente de 45 años presenta paresia facial bilateral de instalación progresiva, en 2 semanas, a lo que luego se agrega parálisis del sexto par craneal. Al examen físico, el tono muscular está disminuido de forma simétrica en las cuatro extremidades, con reflejos osteotendíneos abolidos. **El diagnóstico más probable es:**

A Accidente vascular tronco encefálico
B Miastenia gravis
C Sd. de Guillain Barre
D Botulismo
E Hemorragia intracraneana

Respuesta C. Parálisis facial bilateral progresiva, con otro par craneal y tetraparesia flácida arrefléctica: síndrome de Guillain-Barré. La parálisis facial bilateral nunca se asume como Bell.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 34 años con diarrea autolimitada hace 2 semanas. Hace 4 días inicia hormigueo en los pies y debilidad que sube a los brazos; ahora le cuesta tragar. PA 155/95 lábil, FC 102, SatO2 97 %. Tetraparesia flácida simétrica y arreflexia universal. Solo logra contar hasta 12 en una espiración. LCR: proteínas 145 mg/dL, 2 células/µL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Metilprednisolona 1 g EV por 5 días y control en sala
B Ingreso a UCI, intubación electiva con rocuronio e inmunoglobulina EV
C Intubación con succinilcolina y plasmaféresis más inmunoglobulina
D Hospitalizar en sala y repetir la punción lumbar en 7 días
E Oxígeno por naricera y observar, ya que la saturación es normal

Respuesta B. Guillain-Barré (debilidad ascendente, arreflexia, disociación albúmino-citológica) con compromiso bulbar y conteo menor de 20: falla respiratoria inminente. UCI, intubación electiva sin succinilcolina (rocuronio) e inmunoglobulina EV o plasmaféresis, sin combinarlas. Los corticoides están contraindicados y la saturación normal no tranquiliza.

▶ VER CLASE **1.10.2.014** **Síndrome encefalítico (Herpes Simplex)** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.3 · Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

QUÉ HAY QUE SABER

- Encefalitis herpética (VHS-1, la encefalitis esporádica más frecuente): fiebre + alteración de la función cerebral (conducta bizarra, confusión, alteración de memoria, afasia), crisis focales y alucinaciones olfatorias o gustativas.
- Signos meníngeos ausentes o leves: no esperar rigidez de nuca.
- Ante la sospecha: aciclovir 10 mg/kg c/8 h EV de inmediato por 14–21 días, sin esperar la PCR (baja la mortalidad de >70% a <20%).
- RM: hiperintensidad temporal asimétrica en T2/FLAIR (la TAC puede ser normal las primeras 48–72 h). LCR: pleocitosis linfocítica, glucosa normal, eritrocitos o xantocromía; PCR para VHS-1 confirma (>95%).

- Si hay focalidad, compromiso de conciencia profundo o papiledema, TAC antes de la punción, sin postergar el aciclovir. Diferencial: absceso cerebral (lesión en anillo; no puncionar).
- No requiere seguimiento del médico general: hospitalizar y derivar a neurología/infectología.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 126

Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, consulta por cefalea de 3 días de evolución, a lo que se le ha agregado desorientación y confusión. Además, ha presentado algunas convulsiones clónicas. Se realiza punción lumbar, que da salida a líquido cefalorraquídeo con 100 células por mm3, con 90% mononucleares, con 15 glóbulos rojos por mm3, glucosa: 80 mg/dl, proteínas: 40 mg/dl; glicemia: 100 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Toxoplasmosis cerebral
B Meningoencefalitis herpética
C Tumor cerebral
D Meningitis viral
E Meningitis bacteriana aguda

Respuesta B. Alteración de conciencia y convulsiones con LCR de tipo viral pero hemorrágico (glóbulos rojos): encefalitis herpética.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 42 años, sin antecedentes, con 3 días de fiebre leve, cefalea y conducta cada vez más inapropiada y desinhibida. La esposa relata que no comprende lo que se le dice y dice palabras incoherentes. En la evaluación presenta una crisis tónico-clónica focal en brazo y hemicara derechos. T° 38,4 °C, sin rigidez de nuca franca, afasia sensitiva evidente. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Iniciar aciclovir EV 10 mg/kg cada 8 horas
B Esperar la PCR para VHS en LCR antes de iniciar antivirales
C Iniciar ceftriaxona + metronidazol EV
D Solicitar RMN cerebral y decidir el tratamiento según su resultado
E Iniciar ceftriaxona + vancomicina EV como único tratamiento

Respuesta A. Fiebre, cambio conductual agudo, afasia sensitiva y crisis focales de origen temporal: encefalitis por VHS-1. Se hospitaliza en UTI y se inicia aciclovir EV de inmediato, sin esperar la PCR ni la RMN, porque la letalidad sin tratamiento supera el 70 %.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 42

Paciente con cefalea importante que convulsiona y tiene compromiso de conciencia? (soporoso?), con LCR MN y GR:

A Encefalitis por VHS
B MAB
C Meningitis viral
D Accidente cerebrovascular
E Epilepsia

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Encefalitis por VHS).

▶ VER CLASE 1.10.2.015 Síndromes convulsivos sintomáticos (traumático, por tumores del sistema nervioso central, metabólico, urémico, etc)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.10 · Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Crisis convulsiva secundaria a una causa aguda: TEC, tumor del SNC, ACV, infección (meningitis, encefalitis, absceso, neurocisticercosis), metabólica (hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, uremia) o tóxica (abstinencia alcohólica, cocaína).
- Manejo agudo igual que toda crisis: ABC, glicemia capilar; si dura ≥5 min, lorazepam 4 mg EV o midazolam 10 mg IM y luego levetiracetam o fenitoína EV.
- Estudio: electrolitos, calcio, magnesio, función renal y hepática, tóxicos, ECG y TAC sin contraste; punción lumbar si hay fiebre (tras la imagen si hay focalidad).
- Corregir la causa: glucosa (con tiamina previa en alcohólicos), sodio a velocidad segura, benzodiacepinas en abstinencia, dexametasona en tumor con edema.
- Las crisis metabólicas o tóxicas no requieren antiepiléptico crónico; las estructurales (tumor, secuela de TEC o ACV) sí pueden requerirlo por riesgo de recurrencia.
- Seguimiento: derivar a neurología o neurocirugía según la lesión.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 144

Un adolescente de 14 años presenta cefalea de una semana de evolución. Es traído al servicio de urgencia, tras presentar una convulsión tónico-clónica de 10 minutos de duración, luego de lo que quedó con confusión postictal. Su examen físico no tiene signos focales. Se solicita una tomografía axial computada de cerebro, que muestra una lesión quística de 3 cm en la zona frontotemporal y se realiza una punción lumbar, que muestra proteínas 60 mg/dl, con 70 células por mm3, con 70% de mononucleares y presencia de abundantes eosinófilos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Quiste aracnoidal
B Astrocitoma pilocítico
C Encefalitis herpética
D Meningitis tuberculosa
E Neurocisticercosis

Respuesta E. Primera crisis con una lesión quística en la TAC y eosinófilos en el LCR: neurocisticercosis (Taenia solium). Muestra por qué toda primera crisis lleva neuroimagen: buscar una causa estructural.

▶ VER CLASE 1.10.2.016 Síndromes meníngeos con meningitis purulenta o bacteriana

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.2 · Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

QUÉ HAY QUE SABER

- Meningitis bacteriana: fiebre, cefalea y rigidez de nuca (la tríada completa en <50%; sin ninguna casi se descarta); Kernig y Brudzinski, fotofobia, vómitos, compromiso de conciencia; púrpura sugiere meningococo.
- TAC antes de la punción si hay focalidad, convulsión reciente, Glasgow <10, papiledema o inmunodepresión; pero hemocultivos, dexametasona y antibióticos van antes de la imagen, nunca al revés.
- Dexametasona 10 mg c/6 h EV por 4 días, 15–20 min antes o junto al antibiótico (reduce secuelas auditivas y mortalidad).
- Empírico 3 meses a 50 años: ceftriaxona 2 g c/12 h + vancomicina 15–20 mg/kg c/12 h; agregar ampicilina 2 g c/4 h en >50 años, embarazadas o inmunodeprimidos (Listeria).
- LCR bacteriano: glucosa baja (razón LCR/suero <0,4), PMN >80%, proteínas >100; viral: glucosa normal y mononucleares.
- Notificación obligatoria y quimioprofilaxis de contactos en meningococo (ciprofloxacino o rifampicina). Seguimiento: derivar (audiometría por secuelas).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años, diabético, presenta fiebre de 39 °C, cefalea intensa, rigidez de nuca y somnolencia de 12 horas, sin déficit focal. Punción lumbar: líquido turbio, 2.800 leucocitos/mm3 con 90% polimorfonucleares, proteínas 210 mg/dL y glucosa 15 mg/dL (glicemia 160 mg/dL). **¿Cuál es el tratamiento empírico más adecuado?**

A Ceftriaxona sola
B Penicilina sódica sola
C Aciclovir endovenoso
D Ceftriaxona más ampicilina, junto con dexametasona
E Ciprofloxacino oral

Respuesta D. Un LCR con pleocitosis neutrofílica, proteínas altas y glucosa muy baja confirma una meningitis bacteriana. En mayores de 50 años, embarazadas o inmunosuprimidos se agrega ampicilina a la ceftriaxona para cubrir Listeria, junto con dexametasona antes o con la primera dosis; vancomicina se suma según la resistencia local del neumococo. El aciclovir corresponde a encefalitis herpética.

▶ VER CLASE 1.10.2.017 Status convulsivo

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.9 · Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Estatus epiléptico convulsivo: crisis ≥5 minutos o crisis repetidas sin recuperar conciencia (t1 = 5 min: tratar; t2 = 30 min: daño neuronal irreversible).
- Fase 1 (0–10 min): ABC, oxígeno, glicemia; lorazepam 4 mg EV (0,1 mg/kg), o midazolam 10 mg IM si no hay vía (intranasal o bucal en niños); repetir una vez; diazepam 10 mg EV como alternativa. Nunca fenitoína de entrada.
- Fase 2 (10–30 min): levetiracetam 60 mg/kg EV (máx 4.500 mg), fenitoína 20 mg/kg en suero fisiológico a ≤50 mg/min con monitor (nunca en glucosado) o valproato 40 mg/kg.
- Fase 3 (refractario): intubación, UCI, propofol o midazolam en infusión con EEG continuo.
- Complicaciones: rabdomiólisis e IRA (CK, creatinina, hidratación vigorosa), acidosis láctica, hipertermia; coma sin clonías tras el estatus = EEG por estatus no convulsivo. Embarazada con HTA: sulfato de magnesio.
- Buscar la causa (abandono de antiepilépticos, metabólica, infección, TEC). Seguimiento: derivar a neurología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 10.9

Usted evalúa a un recién nacido, diagnosticado de asfixia, con una encefalopatía hipóxica, cae en estatus epiléptico. ¿Qué fármaco debe administrar?

A Lidocaína
B Barbitúricos
C Sulfato de magnesio
D Fenitoína
E Lamotrigina

Respuesta B. El estatus epiléptico en un recién nacido, especialmente en el contexto de una encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) secundaria a asfixia, es una emergencia neurológica que requiere tratamiento inmediato para prevenir un mayor daño cerebral. El manejo de las convulsiones neonatales sigue un algoritmo escalonado. El fármaco de primera línea o, en su defecto, el segundo tras el fracaso de las benzodiacepinas (que no están en las opciones), es el fenobarbital, un tipo de barbitúrico. El...

▶ VER CLASE 1.10.2.018 Status migrañoso

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.6 · Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

QUÉ HAY QUE SABER

- Status migrañoso: crisis de migraña debilitante de más de 72 horas continuas; descartar banderas rojas antes de atribuirlo a migraña.
- Si la crisis es igual a las habituales y el examen neurológico es normal, no requiere neuroimagen.
- Tratamiento en urgencia: hidratación EV, metoclopramida EV (antiemético antidopaminérgico) y ketorolaco EV; agregar dexametasona para reducir la recurrencia.
- Evitar opioides (cefalea por abuso de medicamentos y recurrencia); no combinar ergotamina con triptán; sumatriptán SC solo si no lo usó en exceso.
- Buscar abuso de analgésicos (AINE ≥15 días/mes, triptán ≥10 días/mes) como factor perpetuante.
- No requiere seguimiento especial tras resolver; indicar profilaxis si cumple criterios (≥3 crisis/mes) y control en APS.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 44 años con epilepsia secundaria a un TEC antiguo, que abandonó sus antiepilépticos hace 5 días. Llega en ambulancia con una crisis tónico-clónica generalizada continua de 25 minutos. Inconsciente, clonías bilaterales, trismus, sialorrea y cianosis peribucal. FC 138 lpm, PA 165/100 mmHg, SatO2 86 % ambiental, T° 38,6 °C. HGT 112 mg/dL. Tiene vía venosa permeable. **Tras asegurar la vía aérea y administrar oxígeno, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Fenitoína 20 mg/kg EV diluida en suero glucosado al 5 %
B Lorazepam 4 mg EV en bolo lento
C Observar 5 minutos más, dado que la crisis podría ceder sola
D Suero glucosado al 30 % EV
E TAC de cerebro urgente antes de administrar fármacos

Respuesta B. Estatus epiléptico convulsivo de 25 minutos: superó con creces t1 (5 min) y se acerca a t2 (30 min). Tras el ABC, el primer fármaco es una benzodiacepina: lorazepam 4 mg EV (midazolam 10 mg IM si no hubiera vía). Si no cede, fase 2 con levetiracetam 60 mg/kg o fenitoína 20 mg/kg en suero fisiológico a ≤ 50 mg/min con monitor. El HGT es normal, así que la glucosa no está indicada.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 32 años con migraña sin aura conocida presenta una crisis de cefalea pulsátil, con náuseas y fotofobia, de 4 días de duración continua, que no ha cedido con naproxeno ni sumatriptán. Examen neurológico normal, sin fiebre ni signos meníngeos. **¿Cuál es el manejo más adecuado en el servicio de urgencia?**

A Morfina endovenosa
B Hidratación, metoclopramida y ketorolaco endovenosos, considerando dexametasona
C Ergotamina más un segundo triptán
D Propranolol oral y alta
E Punción lumbar inmediata

Respuesta B. Una crisis de migraña de más de 72 horas es un status migrañoso. En urgencia se trata con hidratación, un antiemético antidopaminérgico como metoclopramida, un AINE endovenoso como ketorolaco y dexametasona para reducir recurrencias. Los opioides favorecen la cefalea por abuso de medicamentos, ergotamina y triptán no deben combinarse, y el propranolol es profilaxis, no tratamiento agudo.

▶ VER CLASE 1.10.2.019 Traumatismo encéfalo craneano leve

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.12 · Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

QUÉ HAY QUE SABER

- TEC leve: Glasgow 13–15 (80% de las consultas). El objetivo es detectar a quién pedir TAC y evitar el daño secundario.
- TAC de cerebro sin contraste de urgencia si hay: Glasgow <15 a las 2 h, signos de fractura de base de cráneo (ojos de mapache, Battle, otorraquia o rinorraquia), ≥65 años, anticoagulación, vómitos repetidos, amnesia, pérdida de conciencia, mecanismo de alta energía, focalidad o convulsión.
- Sin factores de riesgo: no requiere imágenes; observación de 4–6 horas y alta con un adulto responsable. La radiografía de cráneo no tiene rol.

- Indicaciones de alarma al alta: cefalea progresiva, vómitos, somnolencia, confusión, convulsión, focalidad o salida de líquido por nariz u oído; analgesia con paracetamol.
- Hematoma epidural: golpe temporal, intervalo lúcido y deterioro brusco con midriasis (craneotomía urgente). Subdural: adulto mayor o anticoagulado con deterioro en días.
- Seguimiento completo: control clínico; síntomas posconmocionales (cefalea, mareo, déficit de concentración) se manejan con reposo relativo y retorno gradual a la actividad.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 28 años, sano, se golpea la cabeza al caer de una escalera de 1,5 metros. Sus acompañantes refieren pérdida de conciencia de 1 minuto. En urgencia, 1 hora después, está vigil, con Glasgow 15, sin focalidad neurológica, pero ha vomitado 3 veces y no recuerda el momento de la caída. No usa fármacos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A TAC de cerebro sin contraste

B Radiografía de cráneo y, si es normal, alta

C Alta con indicaciones de alarma, porque el Glasgow es 15

D Resonancia magnética de cerebro electiva

E Punción lumbar para descartar hemorragia subaracnoidea

Respuesta A. Es un TEC leve, pero con factores de riesgo de lesión intracraneana: pérdida de conciencia, vómitos repetidos y amnesia del evento. Requiere TAC de cerebro sin contraste, que muestra la sangre aguda como hiperdensa. El alta sin imagen corresponde solo al TEC leve sin factores de riesgo; la radiografía de cráneo no descarta lesión intracraneana y la resonancia no es el examen de urgencia.

▶ VER CLASE 1.10.2.020 Traumatismo encefalocraneano grave

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.12 · Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

QUÉ HAY QUE SABER

- TEC grave: Glasgow ≤8; requiere intubación con restricción de movimiento cervical (asumir lesión cervical) y manejo ATLS (ABCDE).
- Evitar el daño secundario: nunca hipotensión ni hipoxia (un episodio duplica la mortalidad), normocapnia (no hiperventilar salvo herniación como puente), normotermia, glicemia normal, cabecera a 30° con cuello alineado.
- TAC de cerebro sin contraste inmediato (y de columna cervical): epidural (lente biconvexa, intervalo lúcido) requiere craneotomía urgente; subdural agudo en semiluna.
- Herniación (midriasis unilateral arreactiva, tríada de Cushing): suero hipertónico o manitol (con hipotensión, preferir suero hipertónico) y neurocirugía urgente.
- Fractura de base de cráneo (ojos de mapache, Battle, rinorraquia u otorraquia): sonda orogástrica, nunca nasal; no taponar el oído.
- No requiere seguimiento del médico general: traslado a UPC y neurocirugía.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 30 años se golpea la cabeza contra un mueble. No perdió el conocimiento, no ha vomitado, no tiene cefalea intensa ni amnesia. No usa anticoagulantes. Glasgow 15, examen neurológico normal, sin signos de fractura de base de cráneo. Vive acompañada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar TAC de cerebro sin contraste

B Alta con indicaciones de signos de alarma y vigilancia por un adulto responsable

C Solicitar radiografía de cráneo

D Hospitalizar en observación por 24 horas

E Solicitar resonancia magnética de cerebro

Respuesta B. TEC leve de bajo riesgo: Glasgow 15, sin pérdida de conciencia, vómitos, amnesia, anticoagulación, edad avanzada ni focalidad. No requiere imágenes: se da de alta con signos de alarma, como cefalea progresiva, vómitos, somnolencia o focalidad, y vigilancia por un adulto. La radiografía de cráneo no tiene rol.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 97

Un adolescente de 17 años sufre un accidente de tránsito, en bicicleta, con golpe en la cabeza. Inicialmente está sin signos neurológicos focales, con escala de Glasgow de 15. Se solicita una radiografía de cráneo que muestra una fractura de la escama del temporal. A las 2 horas evoluciona con cefalea intensa y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Se aprecia midriasis derecha, arreactiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Hematoma subdural derecho

B Hematoma epidural derecho

C Hemorragia subaracnoidea

D Contusión encefálica frontal

E Contusión encefálica temporal

Respuesta B. Es un hematoma epidural clásico, tanto por la fractura, como por la clínica de HTEC grave, como por el breve intervalo lúcido.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 142

Un paciente de 72 años sufre una caída en bicicleta, golpeando la cabeza contra el suelo. Es llevado a un servicio de urgencia donde se encuentra en buenas condiciones, sin alteraciones del nivel de conciencia ni del examen neurológico, por lo que es dado de alta a su domicilio, con indicación de reposo y control SOS. Tres días después inicia cefalea progresiva y, al día siguiente, se agregan vómitos y dificultad para mover las extremidades derechas. Al examen físico se encuentra vigil, orientado en el espacio, pero desorientado en el tiempo. En el examen neurológico destaca hemiparesia derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Hematoma epidural
B Hemorragia subaracnoidea
C Hematoma intraparenquimatoso
D Trombosis del seno cavernoso
E Hematoma subdural

Respuesta E. Todo adulto mayor con un TEC debe ser estudiado con TAC de cerebro y cráneo, precisamente porque Genen mayor riesgo de presentar un hematoma subdural. Además, es frecuente que se demore en desarrollar síntomas y alteraciones neurológicas, porque se origina en un sangrado venoso, que puede ser bastante lento. La edad avanzada y la atrofia cerebral son los factores de riesgo más importantes, ya que permiten una mayor movilidad de las venas que se lesionan.

▶ VER CLASE 1.10.2.021 Traumatismo raquimedular

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar lesión raquimedular en todo politraumatizado (caída de altura, zambullida, alta energía) con dolor cervical, déficit motor o sensitivo, o compromiso de conciencia.
- Restricción de movimiento: collar cervical rígido y tabla espinal, movilización en bloque; vía aérea con tracción mandibular e inmovilización manual alineada.
- Shock neurogénico (lesión cervical o torácica alta): hipotensión con bradicardia y piel tibia y seca; fluidos EV y vasopresor (noradrenalina), atropina si la bradicardia es sintomática; descartar antes hemorragia.
- Examen: nivel motor y sensitivo, tono del esfínter anal, priapismo; respiración diafragmática en lesiones cervicales altas.
- Imagen: TAC de columna (la radiografía lateral solo vale si se ve hasta C7-T1); RM si hay déficit neurológico.
- Sonda vesical, prevención de úlceras y TVP. Seguimiento: derivar a neurocirugía o traumatología y luego a rehabilitación.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 97

Adolescente de 17 años sufre un accidente de tránsito en bicicleta, con golpe en la cabeza. Inicialmente está sin signos neurológicos focales, con Glasgow 15. Una radiografía de cráneo muestra una fractura de la escama del temporal. A las 2 horas evoluciona con cefalea intensa y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Se aprecia midriasis derecha, arreactiva. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hematoma subdural derecho
B Hematoma epidural derecho
C Hemorragia subaracnoidea
D Contusión encefálica frontal
E Contusión encefálica temporal

Respuesta B. Fractura de la escama temporal, intervalo lúcido de dos horas y deterioro brusco con midriasis unilateral son el cuadro clásico del hematoma epidural, por rotura de la arteria meníngea media bajo la fractura.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 142

Paciente de 72 años sufre una caída en bicicleta, golpeando la cabeza contra el suelo. Es evaluado en el servicio de urgencia, donde se encuentra en buenas condiciones, sin alteraciones del nivel de conciencia ni del examen neurológico, y es dado de alta con indicación de reposo y control. Tres días después inicia cefalea progresiva, y al día siguiente se agregan vómitos y dificultad para mover las extremidades derechas. Al examen está vigil, orientado en el espacio pero desorientado en el tiempo, con hemiparesia derecha. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hematoma epidural
B Hemorragia subaracnoidea
C Hematoma intraparenquimatoso
D Trombosis del seno cavernoso
E Hematoma subdural

Respuesta E. La edad avanzada, la atrofia cerebral y un mecanismo de sangrado venoso lento explican que los síntomas del hematoma subdural aparezcan varios días después de un golpe que inicialmente pareció leve, algo que no ocurre con el epidural.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 19 años recibe un golpe con un palo en la región temporal izquierda durante un asalto. Pierde el conocimiento por un minuto, se recupera por completo, y queda conversando normalmente en la ambulancia. Una hora y media después, en urgencias, empieza con cefalea intensa, vomita, y en minutos queda en coma, con la pupila izquierda dilatada y sin reflejo a la luz. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hemorragia subaracnoidea aneurismática

B Hematoma epidural agudo

C Hematoma subdural crónico

D Contusión cerebral bifrontal

E Trombosis del seno venoso

Respuesta B. El golpe temporal, la pérdida de conciencia inicial, el intervalo lúcido de más de una hora y el colapso súbito con midriasis ipsilateral son el cuadro clásico del hematoma epidural agudo, por rotura de la arteria meníngea media.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 24 años cae de 4 metros de altura y llega con collar cervical. Está vigil, con vía aérea permeable y ventilación adecuada. Presenta tetraplejia flácida con nivel sensitivo en C6, PA 78/40 mmHg, FC 50/min y piel tibia y seca en extremidades. Eco-FAST negativa y radiografía de pelvis normal. **¿Cuál es la causa más probable de la hipotensión y su manejo inicial?**

A Shock hipovolémico; transfusión masiva

B Shock cardiogénico; dobutamina

C Shock neurogénico; fluidos endovenosos y vasopresor (noradrenalina), con atropina si la bradicardia es sintomática

D Taponamiento cardíaco; pericardiocentesis

E Shock séptico; antibióticos de amplio espectro

Respuesta C. La lesión medular cervical o torácica alta interrumpe el tono simpático y produce shock neurogénico: hipotensión con bradicardia y piel tibia, a diferencia del hipovolémico, que es frío y taquicárdico. Tras descartar sangrado, se trata con fluidos y vasopresores (atropina si la bradicardia es sintomática), manteniendo restricción de movimiento de la columna.

Conocimientos generales

2 códigos

▶ VER CLASE 1.10.3.001 **Manifestaciones neurológicas de abuso de sustancias y alcohol**

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.15 · Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

QUÉ HAY QUE SABER

- Intoxicación alcohólica: ataxia, disartria, nistagmo y compromiso de conciencia; descartar hipoglicemia, TEC (hematoma subdural) y otras drogas.
- Abstinencia: temblor y disautonomía (6–12 h), alucinosis con sensorio lúcido (12–24 h), convulsiones (12–48 h) y delirium tremens (48–96 h, confusión, fiebre, zoopsias). Benzodiacepinas guiadas por CIWA-Ar: diazepam; lorazepam si cirrosis.
- Encefalopatía de Wernicke (déficit de tiamina): oftalmoplejía (VI par, nistagmo), ataxia y confusión (la tríada completa solo en 30%); tiamina 100–300 mg EV antes de cualquier glucosado. Secuela: Korsakoff (amnesia anterógrada y confabulación).
- Daño crónico: degeneración cerebelosa vermiana, polineuropatía, demencia alcohólica, mielinolisis pontina por corrección rápida del sodio.
- Otras drogas: cocaína (ACV, convulsiones; benzodiacepinas, no betabloqueadores), opioides (miosis y bradipnea: naloxona), benzodiacepinas (flumazenil contraindicado en usuarios crónicos).
- Prevención en APS: tamizaje con AUDIT, intervención breve y entrevista motivacional; naltrexona, disulfiram o acamprosato en programa especializado.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 17.15

Un hombre de 52 años en situación de calle con antecedente de alcoholismo crónico severo y desnutrición extrema es llevado a urgencias por compromiso de conciencia progresivo. Al examen físico destaca sopor profundo, nistagmo bilateral horizontal y ataxia de tronco que le impide la bipedestación. La glicemia capilar informa 48 mg/dL. ¿Cuál es la secuencia farmacológica obligatoria que debe administrarse de inmediato?

A Administrar 4 ampollas de suero glucosado al 30% EV en bolo rápido y luego evaluar vitaminas

B Administrar Tiamina 100 mg endovenosa o intramuscular previo o simultáneo a la infusión de suero glucosado

C Administrar Fenitoína 1 g en infusión endovenosa rápida

D Administrar Naloxona 0.4 mg EV y Flumazenil 0.5 mg EV directo

E Administrar Insulina cristalina 10 UI subcutáneas

Respuesta B. El paciente presenta la tríada clásica de la Encefalopatía de Wernicke (oftalmoplejía/nistagmo, ataxia y confusión/sopor) agravada por hipoglicemia severa. La regla de oro absoluta e innegociable en urgencias es que en todo paciente con alcoholismo crónico o desnutrición severa, la administración de TIAMINA (Vitamina B1, 100 a 300 mg EV o IM) DEBE preceder o administrarse de forma estrictamente simultánea al suero glucosado. Administrar glucosa sola (A) consume la escasa tiamina de reserva como...

▶ VER CLASE `1.10.3.002`

Prevención de factores de riesgo cerebrovascular

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.1 · Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES
Neurología 10.2 · Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria

QUÉ HAY QUE SABER

- La HTA es el principal factor de riesgo modificable de ACV isquémico y hemorrágico; otros: FA, diabetes, dislipidemia, tabaco, sedentarismo, obesidad y alcohol.
- Prevención primaria: PA <140/90 (<130/80 en alto riesgo), dejar de fumar, actividad física, dieta con sal <5 g/día, control glicémico y estatina según riesgo cardiovascular (Programa de Salud Cardiovascular).
- Fibrilación auricular: anticoagulación oral según CHA_2DS_2-VASc (anticoagulantes directos o acenocumarol).
- Prevención secundaria no cardioembólica: AAS 100 mg indefinido (AAS + clopidogrel solo 21 días tras AIT o ACV menor), atorvastatina de alta intensidad con LDL <70, PA <130/80.
- Estenosis carotídea sintomática 70–99% (50–69% en hombres): endarterectomía en <2 semanas; cardioembólico: anticoagular.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 151

Una paciente de 67 años presenta un cuadro de hemiparesia faciobraquiocrural derecha autolimitada hace 7 días, manejada adecuadamente en el hospital. Al examen físico se ausculta un soplo cervical izquierdo, sin otras alteraciones. Su examen neurológico es normal. **¿Cuál de los siguientes es el examen más adecuado para realizar el estudio etiológico?**

A Ecocardiograma Doppler color
B Angiografía de arterias cerebrales o de cabeza y cuello
C Resonancia magnética de cerebro
D Ecodoppler de carótidas
E TAC de cerebro

Respuesta D. AIT carotídeo izquierdo con soplo cervical del mismo lado: la sospecha es una estenosis carotídea ipsilateral. El eco-Doppler carotídeo es el examen de estudio vascular; si confirma una estenosis significativa, se indica endarterectomía precoz.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 66 años, hipertenso y dislipidémico, egresa tras un infarto cerebral lacunar capsular izquierdo con buena recuperación. Fuma 10 cigarrillos al día. Ritmo sinusal en Holter de 24 horas y eco-Doppler carotídeo sin estenosis significativa. PA 148/92 mmHg con enalapril, LDL 142 mg/dL, HbA1c 5,6 %. **¿Cuál es la estrategia de prevención secundaria más adecuada?**

A Anticoagulación oral con acenocumarol de por vida
B AAS 100 mg/día, estatina de alta intensidad con meta de LDL menor de 70 mg/dL, PA menor de 130/80 mmHg y cesación tabáquica
C AAS más clopidogrel en forma indefinida
D Solo optimizar la PA, ya que el infarto lacunar no requiere antiagregante
E Estatina solo si el LDL supera 190 mg/dL

Respuesta B. Infarto no cardioembólico (ritmo sinusal, sin estenosis carotídea): antiagregación con AAS a largo plazo, estatina de alta intensidad con meta de LDL menor de 70 mg/dL, PA menor de 130/80 mmHg, cese del tabaco y actividad física. La anticoagulación es para cardioembolia; la doble antiagregación indefinida aumenta el sangrado sin beneficio.

Exámenes e imagenología

7 códigos

▶ VER CLASE `1.10.4.001`

TAC de encefalo y columna

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.12 · Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC
Neurología 10.1 · Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES
Neurología 10.3 · Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos

QUÉ HAY QUE SABER

- TAC de encéfalo sin contraste: primer examen ante déficit focal agudo, cefalea en trueno, TEC con factores de riesgo o compromiso de conciencia; rápido y disponible.
- Sangre aguda hiperdensa (blanca) desde el primer minuto: hematoma intraparenquimatoso, HSA en cisternas, epidural (lente biconvexa, no cruza suturas) o subdural (semiluna, cruza suturas).
- Infarto: el TAC suele ser normal las primeras horas (un TAC normal es compatible con isquemia y permite trombolizar); signos precoces: arteria cerebral media hiperdensa, borramiento del ribete insular; hipodensidad establecida tras horas.
- El contraste se reserva para tumores y abscesos (realce en anillo) o angioTAC (oclusión de gran vaso, aneurisma, trombosis venosa); la TAC normal no descarta trombosis venosa ni infarto de fosa posterior.
- TAC de columna: de elección en trauma raquídeo (la radiografía lateral cervical solo sirve si se visualiza hasta C7-T1).

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 76 años, usuario de acenocumarol por fibrilación auricular, se cae en su casa y se golpea la cabeza. Está con Glasgow 15, sin focalidad neurológica, con un hematoma en la región frontal. **¿Cuál es el examen más adecuado?**

A Radiografía de cráneo

B TAC de cerebro con contraste

C TAC de cerebro sin contraste

D Resonancia magnética de cerebro

E No requiere imágenes por tener Glasgow 15

Respuesta C. Edad mayor de 65 años y anticoagulación son factores de alto riesgo de hemorragia intracraneana aun con Glasgow 15. El examen de elección en trauma es la TAC de cerebro sin contraste: rápida, disponible y muestra la sangre aguda como hiperdensa. El contraste podría confundirse con sangre.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 72 años, hipertensa, es traída a urgencia 50 minutos después de iniciar en forma súbita hemiparesia izquierda faciobraquiocrural y disartria. PA 178/96 mmHg, glicemia capilar 132 mg/dL, NIHSS 9. Se activa el código ACV. **¿Cuál es el examen de imagen que debe realizarse en primer lugar?**

A Resonancia magnética de encéfalo con gadolinio

B TAC de encéfalo con contraste

C TAC de encéfalo sin contraste urgente

D Eco-Doppler carotídeo

E Electroencefalograma

Respuesta C. Ante un déficit focal agudo, el primer examen es el TAC de encéfalo sin contraste, rápido y disponible, cuyo objetivo principal es descartar hemorragia antes de trombolisis. En las primeras horas el infarto suele no verse, por lo que un TAC normal es compatible con isquemia. El contraste dificulta ver sangre; la RM no debe retrasar el tratamiento.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 69 años, hipertensa mal controlada, presenta cefalea brusca, vómitos y hemiparesia derecha de instalación en minutos. PA 210/118 mmHg, Glasgow 13. Se realiza TAC de encéfalo sin contraste a los 40 minutos del inicio. **¿Qué hallazgo del TAC sin contraste confirma una hemorragia intracerebral aguda?**

A Hiperdensidad espontánea intraparenquimatosa en los ganglios basales izquierdos

B Hipodensidad córtico-subcortical en el territorio de la arteria cerebral media

C Lesión con realce en anillo tras la administración de contraste

D Pequeñas hipodensidades lacunares en la cápsula interna

E Hiperdensidad lineal de la arteria cerebral media (signo de la arteria hiperdensa)

Respuesta A. En el TAC sin contraste la sangre aguda es hiperdensa (blanca) desde el primer minuto, por eso es el examen de elección para descartar hemorragia. La hipodensidad en territorio arterial es un infarto establecido (de horas); la arteria hiperdensa es un trombo intraluminal en un ACV isquémico; el realce en anillo sugiere absceso o tumor.

▶ VER CLASE 1.10.4.002 Resonancia magnética de encéfalo y columna

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.5 · Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena
Neurología 10.18 · Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad

QUÉ HAY QUE SABER

- Resonancia magnética: más sensible que la TAC para fosa posterior, isquemia precoz (difusión), lesiones desmielinizantes, tumores, encefalitis y médula; es más lenta y menos disponible.
- Esclerosis múltiple: lesiones ovoides periventriculares perpendiculares al cuerpo calloso (dedos de Dawson), yuxtacorticales, infratentoriales y medulares; las que captan gadolinio son activas.
- Encefalitis herpética: hiperintensidad temporal asimétrica en T2/FLAIR. Trombosis venosa: venografía por RM (signo del delta vacío). Epilepsia: protocolo para esclerosis mesial y displasias.
- RM de columna urgente ante compresión medular (nivel sensitivo, esfínteres), cauda equina o déficit radicular; en lumbago solo si hay banderas rojas.
- No debe retrasar la trombolisis en el ACV agudo; contraindicada con marcapasos no compatible o cuerpos extraños metálicos.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 32 años, usuaria de anticonceptivos orales combinados y fumadora, consulta por 5 días de cefalea holocránea progresiva que empeora con el decúbito, con vómitos y visión borrosa transitoria. Fondo de ojo: edema de papila bilateral. Sin déficit focal. TAC de encéfalo sin contraste: normal. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico más probable?**

A Resonancia magnética de encéfalo con venografía por resonancia

B Punción lumbar con medición de presión de apertura

C Electroencefalograma

D Repetir el TAC sin contraste en 48 horas

E Eco-Doppler carotídeo

Respuesta A. Cefalea progresiva con hipertensión endocraneana en una mujer con anticonceptivos y tabaco: sospecha de trombosis venosa cerebral. El TAC sin contraste suele ser normal; se confirma con RM más venografía por RM (o angio-TAC venoso), que muestran el seno trombosado. La punción lumbar no se hace antes de la imagen adecuada, y no diagnostica la trombosis.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 31 años con 10 días de parestesias y debilidad de la pierna derecha. Hace 2 años tuvo una neuritis óptica izquierda que se recuperó. Examen: paresia 4/5 de la extremidad inferior derecha con hiperreflexia y Babinski derecho. Se solicita RM de encéfalo y médula con gadolinio. **¿Qué hallazgo de la RM apoya con mayor fuerza el diagnóstico más probable?**

A Lesiones ovoides hiperintensas en T2 periventriculares, perpendiculares al cuerpo calloso, más lesiones yuxtacorticales, infratentoriales y medulares

B Infartos lacunares múltiples en los ganglios basales

C Atrofia hipocampal bilateral

D Lesión única con realce en anillo y edema perilesional

E Hiperintensidad simétrica de ambos tálamos

Respuesta A. Dos episodios separados en tiempo y espacio en una mujer joven: esclerosis múltiple. La RM es el examen clave: lesiones desmielinizantes ovoides periventriculares (dedos de Dawson), yuxtacorticales, infratentoriales y medulares cumplen diseminación en espacio; la coexistencia de lesiones que captan y no captan gadolinio cumple diseminación en tiempo (criterios de McDonald).

▶ VER CLASE 1.10.4.003 Angiografía

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.4 · Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino

QUÉ HAY QUE SABER

- Angiografía cerebral por sustracción digital: estándar de referencia para aneurismas, malformaciones arteriovenosas, estenosis y vasculitis; permite tratar en el mismo acto (embolización con coils, trombectomía).
- Indicada tras confirmar hemorragia subaracnoidea (TAC o punción lumbar) para localizar el aneurisma (15–20% son múltiples).
- En el ACV isquémico con oclusión de gran vaso se usa como vía para la trombectomía mecánica.
- Alternativas no invasivas iniciales: angioTAC y angio-RM; eco-Doppler para carótidas y Doppler transcraneal para vigilar vasoespasmo.
- Riesgos: nefropatía por contraste, alergia, ACV embólico y hematoma del sitio de punción. El médico general deriva y emplea el informe.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 48 años con cefalea súbita, "la peor de su vida", de 6 horas de evolución. La TAC de cerebro sin contraste muestra hemorragia subaracnoidea en las cisternas basales. **¿Cuál es el examen de referencia para identificar y caracterizar el aneurisma?**

A Angiografía cerebral por sustracción digital

B Electroencefalograma

C Punción lumbar

D Doppler transcraneal

E Resonancia magnética sin contraste

Respuesta A. Confirmada la hemorragia subaracnoidea, debe identificarse el aneurisma. La angiografía cerebral por sustracción digital es el estándar de referencia: lo localiza, lo caracteriza y permite tratarlo con embolización endovascular en el mismo procedimiento. La angio-TAC es una alternativa inicial no invasiva, y el doppler transcraneal sirve para vigilar el vasoespasmo.

▶ VER CLASE 1.10.4.004 Campo visual

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.20 · Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Campo visual por confrontación (en la consulta) o campimetría computarizada; localiza la lesión de la vía óptica.
- Defecto monocular: lesión de retina o nervio óptico (escotoma central en neuritis óptica, con DPAR).
- Hemianopsia bitemporal (heterónima): lesión del quiasma, típicamente macroadenoma hipofisario o craneofaringioma: RM de silla turca y perfil hormonal.

- Hemianopsia homónima contralateral: lesión retroquiasmática (cintilla, radiaciones, corteza occipital); con preservación macular sugiere infarto de la cerebral posterior. Cuadrantanopsia superior: temporal; inferior: parietal.
- La campimetría documenta el daño y se usa en el seguimiento de tumores selares y glaucoma.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 50 años consulta por cefalea y por chocar con frecuencia con objetos a ambos lados al caminar. La resonancia muestra un macroadenoma hipofisario de 2,5 cm con extensión supraselar. **¿Cuál es la alteración del campo visual más esperable?**

A Hemianopsia homónima derecha

B Hemianopsia bitemporal

C Escotoma central unilateral

D Cuadrantanopsia superior homónima

E Amaurosis monocular transitoria

Respuesta B. Un macroadenoma con extensión supraselar comprime el quiasma óptico desde abajo, afectando las fibras nasales que se cruzan, y produce hemianopsia bitemporal, que típicamente se inicia en los cuadrantes superiores. Por eso todo macroadenoma requiere campimetría. La hemianopsia homónima indica una lesión retroquiasmática, y la amaurosis transitoria, isquemia retiniana.

▶ VER CLASE 1.10.4.005 Electroencefalograma

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.8 · Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES
Neurología 10.10 · Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- EEG: examen de elección para apoyar el diagnóstico y clasificar la epilepsia; busca actividad epileptiforme interictal (puntas, ondas agudas, punta-onda).
- Normal en cerca de la mitad de los epilépticos: un EEG normal no descarta epilepsia; aumentar sensibilidad con privación de sueño, registros repetidos o video-EEG.
- Hallazgos típicos: punta-onda generalizada a 3 Hz en ausencias (gatilladas por hiperventilación), hipsarritmia en el síndrome de West, puntas centrotemporales en epilepsia rolándica, complejos periódicos en Creutzfeldt-Jakob.
- Un EEG epileptiforme tras una primera crisis eleva el riesgo de recurrencia (>60%) y apoya iniciar tratamiento.
- EEG continuo en estatus refractario o paciente que no despierta tras una crisis (estatus no convulsivo). GES: EEG en 30 días en epilepsia ≥15 años.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niña de 7 años, con buen desarrollo, es derivada porque su profesora nota que varias veces al día se queda con la mirada fija por unos 10 segundos, con parpadeo, sin caerse, y retoma la actividad sin confusión. En la consulta se reproduce un episodio al pedirle que hiperventile. **¿Qué hallazgo del electroencefalograma es esperable?**

A Trazado normal, que descarta epilepsia

B Hipsarritmia

C Puntas centrotemporales que aumentan con el sueño

D Complejos periódicos de ondas agudas

E Descargas generalizadas de punta-onda a 3 Hz

Respuesta E. Desconexiones breves y frecuentes, sin período postictal y gatilladas por hiperventilación: epilepsia de ausencia infantil. El EEG característico muestra descargas generalizadas y simétricas de punta-onda a 3 Hz. La hipsarritmia corresponde al síndrome de West; las puntas centrotemporales a la epilepsia rolándica; los complejos periódicos a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 31 años, sano, presenta una primera crisis tónico-clónica generalizada no provocada, presenciada, con mordedura lateral de lengua y confusión postictal de 20 minutos. Examen neurológico y exámenes generales normales; RM de encéfalo normal. El EEG interictal de rutina, realizado a los 5 días, es normal. **¿Cuál es la interpretación más adecuada del EEG?**

A No descarta epilepsia: un EEG interictal es normal en una proporción relevante de pacientes, y puede repetirse con privación de sueño

B Descarta epilepsia y permite dar el alta sin controles

C Confirma una crisis psicógena no epiléptica

D Indica que la crisis fue un síncope convulsivo

E Obliga a iniciar fenitoína de inmediato

Respuesta A. El EEG interictal de rutina detecta descargas epileptiformes solo en una parte de los pacientes con epilepsia; su sensibilidad aumenta con registros repetidos, privación de sueño o video-EEG. Un EEG normal no descarta epilepsia, y uno anormal tras una primera crisis aumenta el riesgo de recurrencia y apoya iniciar tratamiento. El diagnóstico sigue siendo clínico.

▶ VER CLASE **1.10.4.006** **Electromiografia** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.16 · Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo
Neurología 10.17 · Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma

QUÉ HAY QUE SABER

- Electromiografía con velocidad de conducción nerviosa: confirma y gradúa neuropatías, radiculopatías, enfermedades de placa y miopatías.
- Túnel carpiano: confirma la lesión del mediano y su severidad, y orienta la cirugía (atrofia tenar o denervación).
- Polineuropatía: distingue desmielinizante de axonal (diabética, alcohólica). Guillain-Barré: onda F prolongada o ausente y bloqueos de conducción.
- Miastenia: decremento >10% en estimulación repetitiva a 3 Hz; la fibra aislada (jitter) es la más sensible. Miopatía: potenciales miopáticos breves y polifásicos.
- Esclerosis lateral amiotrófica: denervación en varios segmentos. El médico general la solicita o deriva y emplea el informe.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 56

Un paciente de 58 años, diabético tipo 2 de larga data, mal controlado, consulta por dolor en las extremidades inferiores, de tipo urente y que es más intenso en la noche. Al examen físico se aprecia ausencia de la sensibilidad de las extremidades con el uso de monofilamento e importante disminución de los pulsos pedios. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A Estudio Doppler vascular de extremidades inferiores
B Electromiografía
C Resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra
D Angiografía aortofemoral
E Pletismografía de volumen del pulso de extremidades inferiores

Respuesta B. Dolor urente, de predominio nocturno, con monofilamento alterado: polineuropatía diabética. Su diagnóstico es clínico, pero el examen que la objetiva es la electromiografía. Los pulsos disminuidos son un distractor que lleva a los estudios vasculares.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 27

Una paciente de 34 años, cursando un embarazo de 28 semanas, consulta por parestesias en el primer, segundo y tercer dedo de la mano derecha, que empeoran durante la tarde y la noche, asociadas a sensación de debilidad en los mismos dedos. El resto del examen físico es normal. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?**

A Resonancia magnética nuclear de cuello
B Ecografía de muñecas
C Electromiografía
D Radiografía de mano derecha
E Factor reumatoideo

Respuesta C. Túnel carpiano clásico (embarazo, parestesias en los tres primeros dedos, peor en la noche). El examen que lo confirma es la electromiografía con estudio de conducción nerviosa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 56

Paciente de 58 años, diabético tipo 2 mal controlado, consulta por dolor en las extremidades inferiores, de tipo urente y más intenso en la noche. Al examen físico se aprecia ausencia de sensibilidad en las extremidades con el uso de monofilamento. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A Eco-Doppler de extremidades inferiores
B Electromiografía
C Resonancia magnética de columna lumbosacra
D Angiografía aortofemoral
E Pletismografía de volumen del pulso de extremidades inferiores

Respuesta B. Dolor urente nocturno y pérdida de sensibilidad al monofilamento en un diabético mal controlado: polineuropatía diabética. Su diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero el examen que la objetiva es la electromiografía con velocidades de conducción. Doppler, angiografía y pletismografía estudian enfermedad arterial, que da claudicación y no un patrón sensitivo distal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 2

Mujer de 50 años consulta por parestesias en ambas manos, mayores a derecha, que la despiertan en la noche, por lo que debe sacudir las manos para aliviarse. Además presenta dificultad para tomar objetos con las manos. **¿Cuál de los siguientes exámenes es el más adecuado para proseguir el estudio?**

A Ecografía de mano
B Electromiografía
C Prueba de estimulación con edrofonio
D Resonancia magnética de cuello
E Radiografía de mano

Respuesta B. Parestesias nocturnas que alivian al sacudir las manos: síndrome del túnel carpiano. Con debilidad para tomar objetos (compromiso motor), se confirma y gradúa con electromiografía y velocidades de conducción del nervio mediano, que además orientan la cirugía. La prueba de edrofonio estudia miastenia, que da fatigabilidad sin síntomas sensitivos.

▶ VER CLASE **1.10.4.007** **Examen de líquido cefaloraquídeo (citoquímico, bacteriológico)** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.4 · Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino
Neurología 10.16 · Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo
Neurología 10.18 · Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad

QUÉ HAY QUE SABER

- Normal: claro, <5 células (mononucleares), proteínas 15–45 mg/dL, glucosa >60% de la sérica. Hacer TAC antes si hay focalidad, papiledema, Glasgow <10, convulsión reciente o inmunodepresión.
- Bacteriana: turbio, PMN >80%, glucosa baja (razón <0,4), proteínas >100, Gram y cultivo. Viral: linfocitos, glucosa normal, proteínas levemente altas. TBC u hongos: linfocitos con glucosa baja (ADA, tinta china).
- Hemorragia subaracnoidea: glóbulos rojos iguales en los 3 tubos y xantocromía desde las 6–12 h; en la punción traumática los glóbulos rojos disminuyen del tubo 1 al 3 y el sobrenadante es claro.
- Guillain-Barré: disociación albúmino-citológica (proteínas altas con <10 células); >50 células sugiere otra causa.
- Esclerosis múltiple: bandas oligoclonales IgG en LCR ausentes en suero e índice de IgG elevado. Encefalitis herpética: pleocitosis linfocítica con eritrocitos y PCR VHS-1 positiva.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años con cefalea súbita de máxima intensidad en segundos, iniciada hace 10 horas durante el ejercicio. Examen neurológico normal. TAC de encéfalo sin contraste a las 8 horas: normal. Se realiza punción lumbar a las 10 horas del inicio. **¿Qué hallazgo del líquido cefalorraquídeo confirma una hemorragia subaracnoídea?**

A Glóbulos rojos que disminuyen progresivamente del primer al cuarto tubo
B Bandas oligoclonales de IgG
C Proteínas elevadas con celularidad normal
D Glucosa baja con predominio de neutrófilos
E Xantocromía del sobrenadante tras centrifugar

Respuesta E. La xantocromía (sobrenadante amarillo por bilirrubina de la degradación de la hemoglobina) aparece desde las 6 a 12 horas y confirma sangre previa en el espacio subaracnoídeo. Los glóbulos rojos que disminuyen entre tubos sugieren punción traumática. Glucosa baja con neutrófilos es meningitis bacteriana; las bandas oligoclonales orientan a esclerosis múltiple.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 42 años con 10 días de parestesias en manos y pies y debilidad ascendente simétrica, precedida por una gastroenteritis. Examen: tetraparesia de predominio proximal y arreflexia generalizada, sin nivel sensitivo y con esfínteres conservados. Se realiza punción lumbar. **¿Cuál es el resultado del líquido cefalorraquídeo más compatible con el diagnóstico más probable?**

A Proteínas 180 mg/dL, 850 células/mm³ con 90 % de neutrófilos y glucosa 20 mg/dL
B Proteínas 160 mg/dL, 3 células/mm³ y glucosa normal
C Líquido xantocrómico con 12.000 glóbulos rojos/mm³
D Proteínas 40 mg/dL, 2 células/mm³ y glucosa normal, con bandas oligoclonales
E Proteínas 90 mg/dL, 120 células/mm³ de predominio linfocitario y glucosa normal

Respuesta B. Debilidad ascendente arrefléctica tras una infección: síndrome de Guillain-Barré. El LCR típico muestra disociación albúmino-citológica, con proteínas elevadas y menos de 10 células/mm³, más evidente desde la segunda semana. Una pleocitosis mayor de 50 células obliga a buscar otra causa (VIH, linfoma, poliomielitis, enfermedad de Lyme); neutrófilos con glucosa baja es meningitis bacteriana.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 28 años con 1 semana de diplopía e inestabilidad de la marcha. Examen: oftalmoplejía internuclear derecha y ataxia de extremidades. RM: lesiones desmielinizantes periventriculares y en el pedúnculo cerebeloso medio. Se realiza punción lumbar para apoyar el diagnóstico. **¿Qué hallazgo del líquido cefalorraquídeo apoya el diagnóstico de esclerosis múltiple?**

A Glucosa en LCR de 20 mg/dL
B Pleocitosis de 600 células/mm³ con predominio de neutrófilos
C Bandas oligoclonales de IgG presentes en el LCR y ausentes en el suero
D Proteínas de 450 mg/dL
E Xantocromía

Respuesta C. En la esclerosis múltiple el LCR suele ser casi normal (proteínas y células normales o levemente elevadas), pero muestra síntesis intratecal de IgG: bandas oligoclonales en el LCR ausentes en el suero, presentes en más del 90 % de los casos. Según McDonald 2017, pueden reemplazar la diseminación en tiempo. Neutrófilos, glucosa baja o proteínas muy altas sugieren otra causa.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

3 códigos

▶ VER CLASE 1.10.5.001 Papiloscopia (fondo de ojo)

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.18 · Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

QUÉ HAY QUE SABER

- Oftalmoscopía directa en sala oscura, idealmente sin dilatar si se evalúa la pupila en un paciente neurológico; examinar papila, vasos, mácula y periferia.
- Papiledema (hipertensión endocraneana): bilateral, papilas solevantadas de bordes borrosos, pérdida del pulso venoso, ingurgitación venosa y hemorragias peripapilares, con agudeza visual conservada al inicio.
- Ante papiledema: neuroimagen urgente antes de cualquier punción lumbar (riesgo de herniación); causas: tumor, hematoma, hidrocefalia, trombosis venosa, hipertensión intracraneal idiopática.
- Neuritis óptica: fondo de ojo normal en 2/3 (retrobulbar), con DPAR y discromatopsia; papilitis unilateral en 1/3.
- Retinopatía hipertensiva (Keith-Wagener-Barker): grado IV con edema de papila = HTA maligna; hemorragias subhialoideas (Terson) en HSA grave; retinopatía diabética en el control anual.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 28 años con obesidad presenta cefalea holocránea progresiva de 2 meses, peor en la mañana y con maniobras de Valsalva, y oscurecimientos visuales transitorios. Examen neurológico sin déficit focal. Se realiza oftalmoscopía directa (fondo de ojo). **¿Qué hallazgo del fondo de ojo indica hipertensión intracraneana?**

A Microaneurismas y exudados duros

B Excavación papilar aumentada, con relación copa/disco de 0,8

C Mancha rojo cereza en la mácula

D Papilas solevantadas, de bordes borrosos, sin pulso venoso y con hemorragias peripapilares bilaterales

E Palidez papilar unilateral sin edema

Respuesta D. El edema de papila es el signo cardinal de hipertensión intracraneana: papilas solevantadas de bordes borrosos, pérdida del pulso venoso espontáneo, ingurgitación venosa y hemorragias peripapilares, habitualmente bilateral. En esta paciente sugiere hipertensión intracraneana idiopática, que requiere neuroimagen antes de la punción lumbar. La excavación aumentada es propia del glaucoma.

▶ VER CLASE 1.10.5.002 Punción lumbar

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.4 · Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: sospecha de meningitis o encefalitis, HSA con TAC normal (a las 6–12 h), Guillain-Barré, esclerosis múltiple, hipertensión intracraneal idiopática (presión de apertura).
- Contraindicaciones: signos de hipertensión endocraneana o lesión con efecto de masa (TAC previo si hay focalidad, papiledema, Glasgow <10, convulsión reciente o inmunodepresión), infección en el sitio, coagulopatía (plaquetas bajas, INR alto, anticoagulación).
- Técnica: consentimiento, decúbito lateral en posición fetal o sentado, asepsia, anestesia local, punción en L3-L4 o L4-L5 (línea entre crestas ilíacas) con trocar fino; medir presión de apertura y recolectar 3–4 tubos.
- Enviar citoquímico, Gram y cultivo, PCR viral, bandas oligoclonales u otros según sospecha; en meningitis no retrasar los antibióticos por la punción.
- Complicación más frecuente: cefalea pospunción (ortostática; reposo, hidratación, cafeína, parche hemático); raras: herniación, hematoma epidural, infección.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 39 años, fumadora, consulta por cefalea occipital explosiva que alcanzó su máxima intensidad en segundos hace 3 horas, mientras levantaba peso, con un vómito. Nunca había tenido cefaleas así. PA 150/90 mmHg, vigil, sin rigidez de nuca ni déficit focal. TAC de encéfalo sin contraste: normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Alta con analgesia y control si reaparecen los síntomas

B Sumatriptán subcutáneo y observación por 2 horas

C Punción lumbar diferida a las 6–12 horas del inicio para buscar xantocromía

D Nimodipino 60 mg cada 4 horas y alta

E Repetir el TAC sin contraste en 1 semana

Respuesta C. Cefalea en trueno: sospecha de HSA hasta demostrar lo contrario. La ausencia de signos meníngeos a las 3 horas no la descarta (tardan 6–12 h). Con TAC normal, la punción lumbar es obligatoria, idealmente a las 6–12 horas para detectar xantocromía. Si es positiva, sigue el estudio vascular (AngioTAC o angiografía).

▶ VER CLASE 1.10.5.003 Aplicación de tests neurocognitivos de screening (MoCA, Mini-Cog, Mini-Mental)

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.14 · Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

QUÉ HAY QUE SABER

- MMSE (Minimental): 30 puntos, corte <24 ajustado por escolaridad; útil en demencia, poco sensible para deterioro leve (efecto techo en alta escolaridad).
- MoCA: corte <26 (+1 punto si escolaridad ≤12 años); más sensible para deterioro cognitivo leve y funciones ejecutivas.
- Mini-Cog: recuerdo de 3 palabras + test del reloj, rápido para tamizaje; el reloj se altera precozmente en Alzheimer. En el EMPAM se usa el Minimental abreviado (alterado <13 de 19).
- Un test alterado no diagnostica demencia: complementar con evaluación funcional (Pfeffer ≥6 por informante = dependencia; Barthel para actividades básicas) y estudio de causas reversibles.
- Aplicar con el paciente atento, sin delirium (descartarlo con CAM), con lentes y audífonos, en ambiente tranquilo; registrar escolaridad.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 74 años, autovalente, acude a su Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM) en el CESFAM. Su hija refiere que en el último año olvida conversaciones recientes. En el Minimental abreviado obtiene 11 puntos (de un máximo de 19). **¿Cuál es el paso siguiente más adecuado?**

A Diagnosticar demencia e iniciar donepezilo

B Solicitar RM de encéfalo como único estudio

C Repetir el Minimental abreviado en 2 años

D Aplicar el cuestionario de actividades funcionales de Pfeffer a un informante

E Derivar a psiquiatría por probable depresión

Respuesta D. En el EMPAM, un Minimental abreviado menor de 13 puntos es alterado y se complementa con el cuestionario de Pfeffer, respondido por un familiar: un puntaje de 6 o más indica compromiso funcional y sospecha de demencia, que se confirma con evaluación clínica y estudio de causas reversibles. Un test de screening por sí solo no diagnostica demencia.

11

REUMATOLOGÍA

35 CÓDIGOS

138 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	25
Situaciones clínicas de urgencia	2
Conocimientos generales	3
Exámenes e imagenología	4
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	1

Situaciones clínicas

25 códigos

▶ VER CLASE **1.11.1.001** **Artritis psoriática**

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Dermatología 16.5 · Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas
Reumatología 9.18 · Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en paciente con psoriasis (afecta al 15-30% de ellos) que presenta dactilitis («dedo en salchicha»), artritis de interfalángicas distales u oligoartritis asimétrica, entesitis o lumbago inflamatorio.
- Pistas: distrofia ungueal (pitting, onicólisis, manchas en gota de aceite), seronegatividad (FR y anti-CCP negativos) y radiografía con «lápiz en copa» y periostitis en fases avanzadas; forma mutilante con telescopaje.
- Diferencial: artritis reumatoide (nunca da dactilitis y respeta las IFD), gota, artrosis nodal.
- Manejo inicial: AINE para el dolor e infiltración con corticoide en sinovitis o dactilitis localizada; evitar corticoides sistémicos (rebote de la psoriasis).
- Seguimiento: derivar a reumatología para metotrexato semanal + ácido fólico (FARME de elección, trata piel y articulaciones) y biológicos (anti-TNF, anti-IL-17) si es refractaria o axial.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 29

Una paciente de 42 años presenta artritis de las articulaciones interfalángicas distales y proximales de ambas manos, con afectación reciente de una articulación metatarsofalángica. Al examen físico, además de las artritis descritas, presenta múltiples depresiones en las uñas de las manos y engrosamiento de las uñas de los pies. **¿A qué tipo de artritis corresponde este cuadro?**

A Reumatoide
B Reactiva
C Psoriática
D Gotosa
E Lúpica

Respuesta C. Artritis de interfalángicas distales, con pitting ungueal y engrosamiento ungueal, es una artritis psoriásica clásica, incluso sin mencionar placas cutáneas, porque las uñas pueden dar la pista antes que la piel.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2017 · PREGUNTA 38

Hombre de 38 años con antecedente de psoriasis en placas consulta por tumefacción dolorosa difusa y uniforme del segundo dedo de la mano izquierda, que adquiere un aspecto engrosado cilíndrico en "salchicha". Al examen se constata dolor en interfalángicas proximales y distales con dolor a la palpación del trayecto del tendón flexor. Las uñas muestran piqueteado puntiforme (pitting). ¿Cómo se denomina este hallazgo semiológico característico?

A Nódulos de Heberden
B Dactilitis ("dedo en salchicha")
C Pannus sinovial erosivo
D Tofo gotoso interarticular
E Eritema nudoso digital

Respuesta B. La dactilitis o "dedo en salchicha" es la inflamación uniforme y difusa de la totalidad de un dedo ocasionada por la combinación simultánea de sinovitis articular y tenosinovitis de los tendones flexores. Es una manifestación característica y altamente específica de las espondiloartropatías, particularmente de la Artritis Psoriásica y de la Artritis Reactiva.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2023 · PREGUNTA 41

¿Cuál de los siguientes hallazgos en la radiografía simple de manos es característico y distintivo de la fase destructiva de la Artritis Psoriásica en articulaciones interfalángicas distales?

A Osteopenia yuxtaarticular en banda aislada sin neoformación ósea
B Deformidad destructiva con aspecto en lápiz en copa (pencil-in-cup)
C Geodas subcondrales gigantes con esclerosis circular pura
D Condrocalcinosis del fibrocartílago triangular
E Subluxación atloaxoidea aislada

Respuesta B. La imagen radiológica en "lápiz en copa" (pencil-in-cup) en las articulaciones interfalángicas de las manos es clásica de la artritis psoriásica. Se produce por la reabsorción y afilamiento del extremo de la falange media ("lápiz") junto con la erosión cóncava y proliferación perióstica de la base de la falange distal ("copa").

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 36 años con antecedente de psoriasis en placas en codos de 5 años de evolución consulta por dolor e hinchazón en el tercer dedo de la mano derecha de 3 semanas. Al examen físico el dedo completo luce uniformemente engrosado, eritematoso y tumefacto, con aspecto de salchicha, con dolor exquisito a la palpación del tendón flexor y sinovitis de la articulación interfalángica distal. Las uñas muestran múltiples depresiones puntiformes en dedal (pitting) y desprendimiento ungueal distal. El factor reumatoide y los anticuerpos anti-CCP son negativos. **¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y cuál es el fármaco modificador sintético de primera elección?**

A Artritis Psoriásica con dactilitis; indicar Metotrexato oral semanal más ácido fólico

B Artritis reumatoide seronegativa; indicar Sulfasalazina en monoterapia

C Gota tofácea poliarticular; prescribir Alopurinol en dosis altas inmediatas

D Osteoartritis erosiva de manos; prescribir condroitín sulfato y paracetamol SOS

E Tenovaginitis infecciosa bacteriana; hospitalizar para drenaje quirúrgico y cloxacilina

Respuesta A. El cuadro clínico es diagnóstico de Artritis Psoriásica: paciente con antecedente de psoriasis cutánea que debuta con dactilitis ("dedo en salchicha"), compromiso de interfalángica distal, distrofia ungueal característica (pitting y onicólisis) y seronegatividad inmunológica (FR y anti-CCP negativos). El fármaco modificador de la enfermedad sintético de primera elección para la artritis psoriásica periférica es el Metotrexato, que ayuda a controlar simultáneamente la piel y las articulaciones.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 111

Una paciente de 40 años presenta artritis de muñecas y de articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y distales de ambas manos, de 6 semanas de evolución. Recientemente se agregó dolor y aumento de volumen generalizado del segundo ortejo derecho, que le dificulta la marcha. Al examen físico se aprecia aumento de volumen y eritema de las articulaciones descritas, más lesiones deprimidas puntiformes en las uñas de las manos, con engrosamiento de las uñas de los pies. El cuadro descrito corresponde a una artritis de tipo:

A Reumatoide

B Infecciosa

C Reac2va

D Psoriá2ca

E Gotosa

Respuesta D. Dactilitis (dedo en salchicha) con artritis de interfalángicas y compromiso ungueal con depresiones puntiformes y engrosamiento de las uñas corresponde a una artritis psoriásica. La reumatoide no produce dactilitis ni lesiones ungueales de ese tipo, la gotosa es de inicio agudo en una articulación, y la reactiva y la infecciosa tienen otros antecedentes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 129

Un paciente de 30 años presenta lumbago de 6 meses de evolución, intenso, que limita sus actividades y que es más molesto en la mañana y va cediendo durante el día. Al examen físico tiene lesiones descamativas en las rodillas y punteado ungueal y el examen de la columna muestra limitación a la flexión, con test de Schöber modificado de 2 cm. Se solicitan exámenes que muestran VHS: 60 mm/h, PCR: 5,0 mg/dl, anticuerpos antinucleares y factor reumatoide negativos. ¿Cuál es el examen de elección para establecer el diagnóstico en este paciente?

A Radiografía de columna lumbosacra

B Radiografía de columna dorsolumbar

C TAC de columna lumbosacra

D Resonancia magnética de columna dorsolumbar

E Resonancia magnética de articulaciones sacroilíacas

Respuesta E. Es una artritis psoriática clásica, con la pelviespondiloartropatía, que se estudia con RMN de sacroilíacas, como el mejor examen, considerado de elección actualmente (por eso la dejamos como correcta), aunque se suele iniciar con la Rx de sacroilíacas.

▶ VER CLASE 1.11.1.002 **Artritis reactivas** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.19 · Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Artritis reactiva: sinovitis aséptica 1-4 semanas después de una infección urogenital (Chlamydia trachomatis) o entérica (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia); HLA-B27 en hasta 80%.
- Clínica: oligoartritis asimétrica de extremidades inferiores (rodillas, tobillos), dactilitis de ortejos, entesitis; tríada de Reiter: uretritis, conjuntivitis y artritis.
- Lesiones mucocutáneas: balanitis circinada indolora, queratodermia blenorrágica palmoplantar, aftas orales indoloras.
- Confirmación: artrocentesis obligatoria con líquido inflamatorio (20.000-50.000 leucocitos) pero Gram y cultivo estériles; descartar artritis séptica y gonococia diseminada (tenosinovitis, pústulas, responde a ceftriaxona).
- Manejo inicial: AINE en dosis plenas (naproxeno, indometacina); doxiciclina o azitromicina si hay infección por Chlamydia, tratando también a la pareja; corticoide intraarticular si es refractaria.
- Seguimiento: derivar a reumatología si persiste >3-6 meses (sulfasalazina) o hay compromiso axial.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2020 · PREGUNTA 15

¿Cuál de las siguientes combinaciones de hallazgos clínicos conforma la denominación clásica del Síndrome de Reiter?

A Artritis reumatoide, esplenomegalia y neutropenia

B Uretritis, conjuntivitis y artritis periférica asimétrica

C Xerostomía, xeroftalmia y artralgias

D Calcinosis, fenómeno de Raynaud y esclerodactilia

E Aftas orales, aftas genitales y uveítis con hipopión

Respuesta B. El Síndrome de Reiter se define clásicamente por la tríada clínica de: 1) Uretritis no gonocócica (o cervicitis), 2) Conjuntivitis bilateral y 3) Artritis periférica asimétrica de extremidades inferiores. La tríada de AR + esplenomegalia + neutropenia corresponde al síndrome de Felty, y las aftas orogenitales más uveítis a la enfermedad de Behçet.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2023 · PREGUNTA 30

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al líquido sinovial obtenido mediante artrocentesis en un paciente con Artritis Reactiva aguda es CORRECTA?

A Presenta invariablemente tinción de Gram con diplococos gramnegativos intracelulares abundantes

B Es francamente inflamatorio (recuentos de 20.000 a 50.000 leucocitos/mm³) pero rigurosamente ESTÉRIL al cultivo

C Es no inflamatorio con viscosidad normal y menos de 200 leucocitos/mm³

D Contiene cristales de urato monosódico birrefringentes fuertemente negativos

E Presenta microhemorragias masivas por fragilidad capilar pura

Respuesta B. El líquido articular en la artritis reactiva es de tipo inflamatorio (frecuentemente turbio con 20.000 a 50.000 leucocitos/mm³ de predominio polimorfonuclear), pero es típicamente estéril; tanto el Gram como los cultivos bacterianos estándar resultan negativos, confirmando su naturaleza inmunológica postinfecciosa aséptica.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 23 años consulta por dolor e inflamación en rodilla izquierda y tobillo derecho de 10 días de evolución, con gran dificultad para apoyar el pie. Refiere que hace 3 semanas presentó ardor al orinar con escasa secreción uretral blanquecina matinal tras un contacto sexual de riesgo sin protección, a lo que siguió ojo rojo bilateral leve que resolvió espontáneamente. Al examen físico destaca rodilla izquierda con derrame articular a tensión y dactilitis en el segundo dedo del pie derecho. En el glande se aprecian erosiones circulares confluentes no dolorosas (balanitis circinada). La artrocentesis de rodilla da salida a líquido turbio con 32.000 leucocitos/mm³ con Gram negativo y cultivos bacterianos negativos. **¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y cuál es la conducta terapéutica indicada?**

A Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter); iniciar AINEs a dosis plenas, tratar Chlamydia con Doxiciclina y tratar obligatoriamente a su pareja sexual

B Artritis séptica gonocócica; hospitalizar para Ceftriaxona 1 g endovenoso diario por 14 días

C Gota poliarticular aguda; iniciar Alopurinol 300 mg al día de inmediato

D Lupus eritematoso sistémico; iniciar Prednisona e Hidroxicloroquina oral

E Espondilitis anquilosante avanzada; indicar terapia biológica Anti-TNF inmediata

Respuesta A. El cuadro clínico reúne la tríada clásica del Síndrome de Reiter (uretritis previa, conjuntivitis y oligoartritis asimétrica de extremidades inferiores con dactilitis) junto a la lesión mucocutánea patognomónica de balanitis circinada y líquido articular inflamatorio estrictamente estéril. El manejo requiere AINEs a dosis plenas para la inflamación articular, tratamiento antimicrobiano para Chlamydia trachomatis con doxiciclina o azitromicina, y tratamiento epidemiológico mandatorio a la pareja sexual.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 116

Un paciente de 20 años, con antecedente de gastroenteritis aguda hace dos semana, consulta por dolor en tobillo derecho desde hace 1 día. Refiere haber presentado molestias similares hace una semana en rodilla y pie izquierdo. Al examen físico destaca tobillo derecho con eritema leve, sin otros hallazgos. El diagnóstico más probable en este caso es:

A Artritis por cristales

B Artritis por stafilococo aureus

C Artritis por neisseria gonorrhoeae

D Artritis reactiva

E Artritis reumatoídea juvenil

Respuesta D. Diagnóstico: Artritis reactiva (opción D). Oligoartritis migratoria es probablemente una reactiva. En especial si la diarrea fue por Campilobacter. El trastorno adaptativo es una respuesta psicológica a un evento estresante identificable (gatillante) que no cumple criterios de depresión ni de otro trastorno específico.

▶ VER CLASE `1.11.1.003` **Artritis reumatoídea** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Reumatología 9.6 · Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares
Reumatología 9.7 · Artritis Reumatoide: Farmacoterapia, FARME Convencionales, Biológicos y GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones (MCF, IFP y muñecas) con rigidez matinal >1 hora, de ≥6 semanas; respeta IFD y columna dorsolumbar (excepto C1-C2).
- Anti-CCP: especificidad >95% y predice enfermedad erosiva; FR sensible (75%) pero poco específico (ancianos, VHC, Sjögren, endocarditis). Criterios ACR/EULAR 2010: ≥6 de 10 puntos (articulaciones, serología, VHS/PCR, duración).
- Radiografía: osteopenia yuxtaarticular y erosiones marginales. Extraarticulares: nódulos, Sjögren secundario, escleritis, EPID, pleuritis con glucosa muy baja, Felty; la aterosclerosis acelerada es la principal causa de muerte.

- Manejo inicial: AINE y prednisona en dosis bajas como puente; no usar corticoide en monoterapia. GES: derivación expedita ante poliartritis de manos >6 semanas.
- Seguimiento: derivar a reumatología para metotrexato 15-25 mg una vez por semana + ácido fólico 5 mg semanal (nunca diario), en la ventana de oportunidad (primeras 12 semanas), con meta de remisión.
- Antes de biológicos descartar TBC latente (PPD/IGRA + radiografía) y hepatitis B y C; el metotrexato está contraindicado en embarazo (sulfasalazina e hidroxicloroquina son seguras).

PREGUNTAS · 15

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 94

Paciente con dolor articular en MCF e IFP, con rigidez matinal importante. ¿Cuál es el examen específico a solicitar?

A Factor reumatoide (IgM)
B ANA y anti-DNA doble cadena
C Ácido úrico sérico
D Anticuerpos anti-CCP
E HLA-B27

Respuesta D. Ante la sospecha clínica de artritis reumatoide (artritis de MCF e IFP con rigidez matinal), el examen con mayor especificidad diagnóstica (> 95-98%) son los anticuerpos anti-péptidos cíclicos citrulinados (anti-CCP). El factor reumatoide es sensible pero inespecífico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 128

Una paciente de 50 años consulta por artralgias y edema de las manos, especialmente en las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y en las muñecas de ambas manos. Refiere fenómeno de Raynaud y rigidez matinal de 1 hora de duración. Además, relata sensación de arenilla ocular y boca seca. Se solicitan exámenes, que muestran hemograma normal, VHS: 52 mm/h, PCR: 2,8 mg/dl, anticuerpos antinucleares positivos en titulación 1/80, factor reumatoide: 118 UI/ml y anticuerpos anti-CCP: 200 UI/ml. La radiografía de manos muestra osteopenia yuxtarticular de los huesos metacarpianos. **El diagnóstico más probable es:**

A Lupus eritematoso sistémico
B Artritis reumatoide
C Vasculitis primaria
D Esclerosis sistémica
E Síndrome de Sjögren primario

Respuesta B. Poliartritis simétrica en manos (MCF, IFP, muñecas) con rigidez matinal de 1 hora, osteopenia yuxtaarticular en radiografía y títulos muy altos de anti-CCP (200 UI/ml) y factor reumatoide confirma Artritis Reumatoide. La presencia de xeroftalmia y xerostomía corresponde a un Síndrome de Sjögren secundario.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2017 · PREGUNTA 21

Mujer de 40 años diagnosticada de artritis reumatoide activa inicia tratamiento con Metotrexato a dosis de 15 mg por semana. ¿Qué fármaco coadyuvante es indispensable prescribir conjuntamente de forma semanal para prevenir toxicidad hematológica, hepática y mucocutánea?

A Ácido fólico 5 mg semanal administrado 24 a 48 horas post-metotrexato
B Vitamina B12 1.000 mcg intramuscular mensual
C Hierro sacarato 200 mg endovenoso trisemanal
D Carbonato de calcio 1.500 mg diario más colecalciferol
E Omeprazol 40 mg diario en ayunas de por vida

Respuesta A. El Metotrexato es un antagonista competitivo de la dihidrofolato reductasa. La administración complementaria de Ácido Fólico a dosis de 5 a 10 mg semanales (administrado 24 a 48 horas después del día de toma de metotrexato) es obligatoria, ya que reduce drásticamente los efectos adversos de intolerancia gastrointestinal, estomatitis aftosa, citopenias medulares y elevación de transaminasas sin mermar la eficacia clínica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2019 · PREGUNTA 08

Hombre de 50 años con artritis reumatoide severa mantiene actividad inflamatoria alta (DAS28 de 5.4) tras 6 meses de tratamiento optimizado con Metotrexato 25 mg/semana más Leflunomida 20 mg/día. Se decide iniciar terapia biológica con Adalimumab (anticuerpo monoclonal anti-TNF alfa). ¿Qué conducta médica es OBLIGATORIA e ineludible antes de administrar la primera dosis del biológico?

A Realizar artroscopía diagnóstica de rodilla con biopsia sinovial
B Descartar infección tuberculosa latente mediante PPD o IGRA y radiografía de tórax
C Administrar vacuna con virus vivos atenuados contra fiebre amarilla
D Suspender permanentemente el metotrexato 3 meses antes
E Indicar pulsos de metilprednisolona 1 g EV por 3 días consecutivos

Respuesta B. Los fármacos bloqueadores del TNF-alfa interfieren de forma crítica con la formación y mantenimiento de los granulomas de defensa frente a Mycobacterium tuberculosis. Por ello, antes de iniciar cualquier anti-TNF es estrictamente obligatorio descartar tuberculosis latente mediante PPD (o IGRA) y radiografía de tórax. Si el tamizaje es positivo, debe iniciarse quimioprofilaxis con isoniazida al menos 1 mes antes del biológico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2021 · PREGUNTA 44

¿Cuál de las siguientes es una CONTRAINDICACIÓN absoluta para el uso de Metotrexato en un paciente con artritis reumatoide recién diagnosticada?

A Hipertensión arterial controlada con enalapril

B Embarazo activo o deseo inminente de gestación

C Osteopenia en densitometría ósea de cadera

D Presencia de nódulos reumatoideos en olécranon

E Edad mayor a 55 años

Respuesta B. El Metotrexato es un fármaco con potencial teratogénico y abortivo demostrado (categoría X), por lo que el embarazo activo o el deseo de embarazo en el corto plazo constituyen una contraindicación absoluta para su prescripción en mujeres y hombres en edad reproductiva. Debe suspenderse al menos 3 a 6 meses antes de planificar la concepción, pudiendo utilizarse Sulfasalazina como alternativa segura.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2023 · PREGUNTA 37

Una paciente de 52 años con artritis reumatoide en tratamiento con Metotrexato oral a dosis de 15 mg/semana desde hace 2 meses consulta a control. El examen físico muestra persistencia de 8 articulaciones tumefactas y rigidez matinal de 1 hora. Las transaminasas y el hemograma son estrictamente normales. ¿Cuál es la conducta terapéutica indicada según la estrategia Treat-to-Target?

A Suspender de inmediato el metotrexato y derivar a cirugía protésica

B Optimizar la dosis de metotrexato aumentándola a 20 – 25 mg por semana

C Cambiar el tratamiento a prednisona 60 mg al día en monoterapia

D Mantener la misma dosis por 2 años antes de evaluar cambios

E Suspender todo tratamiento inmunosupresor e indicar reposo absoluto

Respuesta B. En la estrategia Treat-to-Target, si a los 2-3 meses de tratamiento inicial con metotrexato el paciente mantiene actividad inflamatoria clínica y los controles de laboratorio (hemograma y transaminasas) demuestran excelente tolerancia biológica, la conducta indicada es optimizar el fármaco escalando la dosis semanal hacia el rango pleno eficaz de 20 a 25 mg/semana (o cambiar a vía subcutánea).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 46 años consulta por 8 semanas de dolor y tumefacción simétrica en articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y muñecas de ambas manos, con rigidez matinal de 90 minutos que dificulta sus labores matutinas. Al examen físico destaca sinovitis activa en 8 articulaciones de las manos, sin compromiso de interfalángicas distales. Sus exámenes muestran VHS de 48 mm/h, PCR de 3,2 mg/dl y anticuerpos anti-CCP fuertemente positivos a títulos de 180 UI/ml (valor de corte 20 UI/ml). Radiografía de manos muestra osteopenia yuxtaarticular. **Según los criterios ACR/EULAR 2010, ¿cuál es el puntaje acumulado y la conducta diagnóstica?**

A 4 puntos; no cumple criterios, se descarta artritis reumatoide

B 5 puntos; sospecha intermedia, solicitar resonancia magnética

C 8 puntos; diagnóstico confirmado de artritis reumatoide

D 7 puntos; requiere biopsia sinovial obligatoria para confirmación

E 2 puntos; el cuadro corresponde a artrosis nodal de manos

Respuesta C. La paciente suma 8 puntos en los criterios ACR/EULAR 2010: 3 puntos por 4 a 10 articulaciones pequeñas afectadas + 3 puntos por anti-CCP a títulos altos (> 3 veces el corte) + 1 punto por reactantes elevados (VHS/PCR) + 1 punto por duración ≥ 6 semanas. Con ≥ 6 puntos el diagnóstico de artritis reumatoide es de certeza.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 48 años con diagnóstico reciente de artritis reumatoide seropositiva (anti-CCP fuertemente positivo) consulta para iniciar tratamiento. Presenta sinovitis activa en manos y pies con rigidez matinal de 2 horas. No tiene antecedentes de hepatopatía ni consumo de alcohol, y su hemograma y creatinina son normales. Prueba de embarazo negativa. **¿Cuál es el esquema farmacológico de primera línea más adecuado para iniciar hoy?**

A Prednisona 20 mg al día en monoterapia permanente

B Metotrexato 15 mg semanal + Ácido fólico 5 mg semanal + Prednisona 5 mg/día en pauta descendente

C Infliximab endovenoso cada 8 semanas en monoterapia

D Celecoxib 200 mg al día como único tratamiento

E Metotrexato 15 mg al día vía oral + Ácido fólico diario

Respuesta B. El tratamiento de primera línea de la artritis reumatoide recién diagnosticada se basa en el inicio precoz de Metotrexato a dosis de 15 a 25 mg una vez por semana (fármaco ancla), asociado obligatoriamente a Ácido fólico (5 mg semanal) para prevenir toxicidad. Se añade un corticoide a dosis bajas (prednisona ≤ 5-7.5 mg/día) como terapia puente durante las primeras semanas mientras el metotrexato alcanza su efecto pleno. El metotrexato diario (opción E) es un error letal por riesgo de aplasia medular.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 20

Una paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento, con cuadro de tres meses de dolor en ambas manos y muñecas, asociados a rigidez matinal de 2 horas de evolución. Al examen físico se aprecia compromiso en ambas manos de articulaciones metacarpofalángica e interfalangicas proximales. Se solicita radiografía de manos que muestra erosión de la base de la quinta articulación metacarpofalángica. Además se solicita factor reumatoídeo que resulta negativo y péptido citrulinado que también resulta negativo. El diagnóstico más probable es:

A Artritis reumatoídea
B Artritis psoriática
C Osteoartritis
D Espondilitis anquilosante
E Lupus con compromiso articular

Respuesta A. Diagnóstico: Artritis reumatoídea (opción A). Es una AR de libro, aunque tenga negativos los marcadores.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 132

Una paciente de 54 años ha presentado dolores simétricos en pequeñas y grandes articulaciones, con compromiso de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, que iniciaron hace un año, y que se asocian a rigidez matinal de más de una hora y a sensación de arenilla y sequedad ocular. Se solicitan exámenes que muestran PCR: 10, factor reumatoideo: negativo, anticuerpos antinucleares: negativo y anticuerpos anti- CCP negativos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Artritis reumatoidea
B Artritis reactiva
C Artrosis
D Atritis psoriatica.
E Síndrome de Sjörgren primario

Respuesta A. Diagnóstico: Artritis reumatoidea (opción A). Aunque los marcadores estén negativos, es una AR clásica. Tiene además un Sjögren secundario.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 160

Una mujer de 50 años, sin antecedentes, presenta cuadro de dos meses de dolor en ambas manos asociados a rigidez matinal de 40 minutos de duración que disminuye con los movimientos. Al examen físico destaca eritema en articulaciones metacarpofalangicas de ambas manos, sin otros síntomas. Se solicita factor reumatoideo que resulta positivo y péptido citrulinado que resulta negativo. El tratamiento de elección para esta enfermedad es:

A Metotrexato
B Inmunoglobulina G no específica
C Antiinflamatorios no esteroidales
D Corticoides
E Hidroxicloroquina

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Metotrexato (opción A). Es una AR, aunque tenga negativo el anti-CCP.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 46

Mujer con dolor en metacarpofalángicas, IFP y rodillas, con dolor matutino mayor a 1 hora ¿Cuál es el diagnóstico? a. Artritis Reumatoide

A Hemograma y VHS
B Ecografía
C Radiografía
D TAC con contraste
E Resonancia magnética

Respuesta A. Diagnóstico: Hemograma y VHS (opción A).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 130

Una paciente de 45 años consulta por dolores articulares en muñecas, articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales de ambas manos, asociado a dolor en el codo derecho y la rodilla izquierda. Además, se queja de rigidez matinal, que dura cerca de 4 horas. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, eritema y aumento de la temperatura local de varias de las articulaciones descritas. ¿Cuál es el examen más específico para el diagnóstico de esta patología?

A Anticuerpos anti DNA nativo
B Anticuerpos anti citoplasma de neutrófilos
C Anticuerpos antinucleares
D Anticuerpos anti-CCP
E HLA B27

Respuesta D. Diagnóstico: Anticuerpos anti-CCP (opción D).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 46

Una paciente de 39 años consulta por deseos de embarazo. Tiene antecedente de artritis reumatoide, en tratamiento con paracetamol. Refiere artralgias de manos con frecuencia. Al examen físico no tiene signos inflamatorios, salvo en una de las articulaciones metacarpofalángicas derechas. Trae factor reumatoideo y anticuerpos antiCCP positivos a títulos elevados y una radiogargía de manos, con lesiones erosivas en algunas articulaciones interfalángicas proximales. ¿Cuál es el tratamiento más indicado en esta paciente?

A Metotrexato
B Leflunomide
C Azulfidine
D Anticuerpos contra el receptor de TNF alfa
E Plaquinol

Respuesta D. En la artritis reumatoide activa y erosiva de una paciente que desea embarazo, el metotrexato y el leflunomide están contraindicados por teratogenicidad y se deben suspender antes de concebir. Entre las opciones, el anti-TNF es la alternativa biológica con mejor evidencia de seguridad en la gestación y controla una enfermedad con anti-CCP elevado y erosiones. Es una pregunta de manejo especializado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 5

Una mujer de 40 años presenta artralgias y rigidez matinal, que afecta especialmente las muñecas, articulaciones metacarpofalángicas y, desde hace algunos meses, también afecta los tobillos y articulaciones metatarsofalánficas. Al examen tiene artritis de varias a de las articulaciones descritas. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para determinar el curso clínico de la enfermedad?

A Velocidad de sedimentación hemática
B Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo
C Anticuerpos antipéptido citrulinado
D Proteína C reactiva
E Anticuerpos antinuclerares

Respuesta C. Los anticuerpos anti péptido citrulinado cíclico, además de ser diagnósticos, se asocian a una enfermedad erosiva y de peor pronóstico en la artritis reumatoide, por lo que sirven para predecir el curso clínico. La velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva reflejan actividad inflamatoria puntual y los anticuerpos antinucleares y ANCA corresponden a otras enfermedades.

▶ VER CLASE 1.11.1.004 Artrosis

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.4 · Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada

QUÉ HAY QUE SABER

- Artrosis: degeneración del cartílago con remodelación ósea; dolor mecánico que empeora con el uso y cede con el reposo, rigidez matinal <30 min, crepitación, sin signos inflamatorios.
- Localizaciones: IFD (Heberden), IFP (Bouchard), rizartrosis (1.ª carpometacarpiana), rodilla y cadera (dolor inguinal con pérdida de rotación interna).
- Confirmación: radiografía con carga: pinzamiento asimétrico, esclerosis subcondral, osteofitos y geodas, sin osteopenia ni erosiones; reactantes normales. FR/ANA bajos en ancianos no cambian el diagnóstico.
- Manejo inicial: baja de peso (5-10%), ejercicio y fortalecimiento de cuádriceps, kinesioterapia; paracetamol hasta 3-4 g/día como primera línea.
- Si no basta: AINE tópico u oral breve (con omeprazol); en insuficiencia cardíaca, IRC o úlcera saltar a tramadol. Infiltración con corticoide en brotes.
- Seguimiento completo en APS; derivar a traumatología si el dolor es refractario o incapacitante (artroplastia; GES de endoprótesis de cadera en ≥65 años).

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 121

Una paciente de 64 años consulta por artralgias de las manos, caderas y rodillas. Al examen físico presenta aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas, con nódulos de Heberden. Además tiene limitación de los movimientos de las rodillas, con dolor y crepitación articular, sin signos inflamatorios y limitación a la abducción de ambas caderas. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A Prednisona
B Paracetamol
C Metotrexato
D Bifosfonatos
E Ibuprofeno

Respuesta B. La presencia de nódulos de Heberden, crepitación ósea articular sin calor ni eritema y limitación mecánica confirma artrosis poliarticular. La primera línea de tratamiento analgésico es el paracetamol.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 102

Una paciente de 61 años consulta por dolor articular de ambas manos. Al examen se aprecia aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Se solicita radiografía de manos, que muestra disminución simétrica del espacio interarticular de las articulaciones interfalángicas, con compromiso de la primera articulación carpometacarpiana bilateral, con presencia de quistes subcondrales. Los ANA y FR resultan positivos. **El diagnóstico más probable es:**

A Artritis psoriática
B Artritis reumatoide
C Artritis reactiva
D Condrocalcinosis
E Artrosis

Respuesta E. Compromiso de articulaciones interfalángicas distales (Heberden), proximales (Bouchard) y de la primera carpometacarpiana (rizartrosis), asociado a quistes subcondrales en la radiografía, es patognomónico de artrosis nodal de manos. La positividad a títulos bajos de ANA y FR es un hallazgo inespecífico común en adultos mayores que no debe desviar el diagnóstico clínico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 95

Paciente con artralgias en IFD e IFP, rigidez matinal de 3-5 minutos, dolor que aumenta con actividad. Radiografía: disminución de espacio articular, esclerosis subcondral y osteofitos. **¿Diagnóstico?**

A Artritis reumatoide
B Artrosis
C Artritis psoriásica
D Artritis gotosa crónica
E Espondilitis anquilosante

Respuesta B. Dolor mecánico, que aumenta con la actividad, rigidez matinal muy corta y una radiografía con disminución del espacio articular, esclerosis subcondral y osteofitos: artrosis.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 64 años con sobrepeso consulta por dolor en ambas rodillas de 8 meses de evolución, que empeora al subir escaleras y al caminar distancias largas, aliviando con el reposo. Al examen físico destaca crepitación ósea articular a la flexión de rodillas y presencia de nódulos duros e indoloros en articulaciones interfalángicas distales de ambas manos. Radiografía de rodillas muestra pinzamiento femorotibial medial asimétrico y osteofitos marginales. **¿Cuál es la primera medida farmacológica más adecuada para iniciar su tratamiento?**

A Prednisona 20 mg al día por vía oral
B Paracetamol 1 g cada 8 horas por vía oral
C Metotrexato 15 mg por vía oral una vez a la semana
D Infiltración intraarticular con ácido hialurónico
E Celecoxib 200 mg al día de forma permanente

Respuesta B. Cuadro clínico y radiológico clásico de osteoartritis (gonartrosis y nódulos de Heberden en IFD). La primera línea farmacológica según las guías clínicas y el estándar EUNACOM es el paracetamol en dosis de hasta 3-4 g/día, asociado a medidas no farmacológicas como baja de peso y kinesioterapia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 137

Una paciente de 63 años presenta dolor en articulaciones de las manos, mayores en las articulaciones interfalángicas distales y proximales, asociadas a rigidez matinal de 5 minutos. Además, refiere dificultades para las actividades que requieren mayor prensión de las manos. Se realiza radiografía de manos, que muestra disminución del espacio articular, con esclerosis subcondral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Artritis reumatoide
B Artritis psoriática
C Osteoartritis
D Osteoporosis
E Artritis reactiva

Respuesta C. Diagnóstico: Osteoartritis (opción C). A todos, con este video vamos a empezar con el tema de reumatología y los primeros dos temas que vamos a ver son artrosis y la monotítica y aguga, que incluye artítica por cristales y además la artítica y séptica.

▶ VER CLASE `1.11.1.005` **Cervicalgia** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.15 · Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- Cervicalgia: dolor de cuello, mecánico en la gran mayoría (posturas, contractura, espondiloartrosis); cervicobraquialgia si irradia al brazo por compromiso radicular.
- Prueba de Spurling (extensión y rotación del cuello hacia el lado afectado) reproduce el dolor radicular; evaluar fuerza, sensibilidad y reflejos del miembro superior.
- Banderas rojas: fiebre, baja de peso, antecedente de cáncer, trauma, déficit neurológico progresivo, signos de mielopatía (marcha, torpeza de manos, Babinski) o AR (inestabilidad C1-C2).

- Sin banderas rojas no se piden imágenes: el diagnóstico es clínico.
- Tratamiento: AINE o paracetamol, calor local, mantener la actividad, educación postural y kinesioterapia; evitar el collarín prolongado. La mayoría mejora en 4-6 semanas.
- Seguimiento completo en APS; RM y derivación si hay banderas rojas, déficit neurológico o falla del tratamiento médico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 45 años consulta por dolor cervical de 3 semanas que se irradia al brazo derecho. No tiene fiebre, baja de peso ni debilidad, y el examen neurológico es normal. La prueba de Spurling reproduce el dolor en el brazo. **¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A Resonancia cervical urgente

B Antiinflamatorios y kinesioterapia

C Cirugía cervical

D Collarín rígido por tiempo prolongado

E Corticoides orales como primera línea

Respuesta B. Es una cervicobraquialgia, que sigue la misma lógica del lumbago: manejo médico inicial con antiinflamatorios y kinesioterapia. La resonancia se pide solo con signos de alarma, y la cirugía solo si fracasa un tratamiento médico bien llevado o hay déficit neurológico agudo.

▶ VER CLASE 1.11.1.006 Columna dolorosa

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.16 · Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico

QUÉ HAY QUE SABER

- Clasificar el dolor de columna: mecánico (la mayoría; empeora con la carga y mejora con el reposo) versus inflamatorio (espondiloartritis) versus banderas rojas (infección, tumor, fractura, cauda equina).
- Lumbago inflamatorio (ASAS, ≥4 de 5): inicio <45 años, insidioso, >3 meses, mejora con el ejercicio, no con el reposo, dolor nocturno en la segunda mitad de la noche, rigidez matinal >30 min y excelente respuesta a AINE.
- Banderas rojas: edad >50 o <20 años, fiebre, baja de peso, cáncer previo, trauma, dolor nocturno continuo, déficit neurológico, anestesia en silla de montar o alteración esfinteriana.
- Lumbago mecánico sin alarma: AINE o paracetamol, mantenerse activo (no reposo en cama), calor local, kinesioterapia al ceder el dolor; sin imágenes en las primeras 4-6 semanas.
- Sospecha de espondiloartritis: radiografía de pelvis (sacroilíacas), RM STIR si es normal, HLA-B27, AINE en dosis plenas y derivar a reumatología.
- Seguimiento completo en APS del dolor mecánico; reevaluar si persiste >6 semanas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 26 años consulta por dolor lumbar de 6 meses, de inicio insidioso, que lo despierta en la segunda mitad de la noche y se acompaña de rigidez matinal de 1 hora. **¿Cuál característica adicional apoya más un origen inflamatorio del dolor?**

A Mejoría con el reposo

B Inicio súbito tras levantar peso

C Mejoría con el ejercicio

D Dolor que aumenta al final del día con la actividad

E Irradiación por el dermatoma L5 con Lasègue positivo

Respuesta C. El dolor lumbar inflamatorio (criterios ASAS) se caracteriza por inicio antes de los 40 años, comienzo insidioso, duración mayor de 3 meses, dolor nocturno, rigidez matinal prolongada y mejoría con el ejercicio pero no con el reposo. Sugiere espondiloartritis y se estudia con HLA-B27 y resonancia de sacroilíacas. El dolor mecánico empeora con la actividad y mejora con el reposo.

▶ VER CLASE 1.11.1.007 Condrocalcinosis

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.3 · Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)

QUÉ HAY QUE SABER

- Condrocalcinosis (pseudogota): depósito de cristales de pirofosfato de calcio, típica del adulto mayor; monoartritis aguda de rodilla (>50%) o muñeca, gatillada por reposo, cirugía u hospitalización.
- Confirmación: artrocentesis con cristales romboidales de birrefringencia débilmente positiva; el líquido puede superar 100.000 leucocitos y simular infección, por lo que siempre se pide Gram y cultivo (pueden coexistir).
- Radiografía: calcificación lineal de meniscos y del fibrocartílago triangular de la muñeca.
- Buscar causas secundarias en <60 años o formas poliarticulares: hemocromatosis, hiperparatiroidismo, hipomagnesemia, hipofosfatasia.
- Crisis: AINE, colchicina o corticoide intraarticular (descartada la infección); no hay fármaco que disuelva los cristales y el alopurinol no sirve.
- Seguimiento: derivar a reumatología; colchicina profiláctica en crisis recurrentes.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 64

Un paciente de 81 años presenta dolor muy intenso en la rodilla derecha, con EVA 8/10, que le impide caminar. En su examen físico, se aprecia eritema y aumento de volumen de la rodilla. Se solicita radiografía de rodilla, que muestra calcificación meniscal. Además, se realiza punción articular, que da salida a un líquido sinovial, con 160.000 glóbulos blancos por mm³, sin visualización de bacterias y con presencia de cristales con elongación positiva débil. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Artritis séptica
B Artritis por cristales de pirofosfato de calcio
C Artritis por cristales de hidroxiapatita de calcio
D Artritis por oxalato de calcio
E Gota

Respuesta B. Condrocalcinosis (pseudogota) clásica en paciente anciano: monoartritis de rodilla con calcificación meniscal en la radiografía y líquido sinovial con cristales de birrefringencia positiva débil (elongación positiva). Aunque el recuento leucocitario es descomunal (160.000 GB/mm³), la ausencia de bacterias y los cristales confirman artritis por pirofosfato.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 2

Un paciente de 75 años, es hospitalizado hace 2 días, por un accidente vascular encefálico. Presenta dolor, eritema y aumento de volumen de la rodilla izquierda, con impotencia funcional. Al examen se aprecia eritema y signos de derrame articular. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Artritis séptica
B Artritis por cristales
C Artritis reactiva
D Artritis reumatoide
E Osteoartritis

Respuesta B. La condrocalcinosis es la causa más frecuente de monoartritis aguda en el adulto mayor y suele desencadenarse por el reposo, como en este paciente hospitalizado. Hay que descartar infección con la punción articular.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 96

Paciente con varios episodios de artritis de rodilla; punción muestra cristales de pirofosfato de calcio intracelulares. **¿Tratamiento para prevenir nuevas crisis?**

A AINES a demanda
B Alopurinol
C Metotrexato oral semanal
D Infiltración con corticoides
E Colchicina profiláctica

Respuesta E. Con cristales de pirofosfato de calcio, es una pseudogota recurrente. Para prevenir nuevas crisis se usa colchicina profiláctica; el alopurinol es para el urato.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 132

Un paciente de 70 años ha presentado 3 episodios de dolor y aumento de volumen de la rodilla derecha, que le impide o dificulta la marcha, pero que ha respondido a analgésicos. Acude nuevamente por los mismos síntomas, objetivándose artritis de rodilla derecha, con signos de derrame articular, por lo que se punciona, dando salida a un líquido articular inflamatorio, con abundantes cristales de pirofosfato de calcio, sin bacterias. ¿Qué fármaco es más adecuado para evitar recurrencias?

A Colchicina
B Naproxeno
C Alopurinol
D Hidroclorotiazida
E Metotrexato

Respuesta A. La opción correcta es la A (Colchicina). En este escenario clínico, colchicina se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

▶ VER CLASE `1.11.1.008` **Epicondilalgia, epitroclealgias** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.11 · Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Epicondilitis lateral («codo de tenista»): tendinopatía de los extensores (extensor radial corto del carpo) por sobreuso; dolor en la cara lateral del codo que aumenta con la extensión resistida de la muñeca (prueba de Cozen).
- Epitrocleítis («codo de golfista»): dolor en la cara medial del codo que aumenta con la flexión y pronación resistidas de la muñeca.
- Diagnóstico clínico: dolor a la palpación de la inserción, sin eritema ni aumento de volumen (descarta bursitis olecraniana y artritis séptica).
- Manejo inicial: modificar la actividad repetitiva, AINE, frío local, epicondilera (ortesis) y kinesioterapia con ejercicios excéntricos; infiltración con corticoide solo en casos refractarios.
- Seguimiento completo en APS; la mayoría resuelve en semanas a meses. Derivar si persiste >6-12 meses pese al tratamiento.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 42 años, que trabaja en una fábrica de empaque con movimientos repetitivos de la muñeca, consulta por dolor en la cara lateral del codo derecho de 2 meses. Al examen presenta dolor a la palpación del epicóndilo lateral y al extender la muñeca contra resistencia. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Epitrocleítis (codo de golfista)

B Artritis reumatoide

C Bursitis olecraneana

D Síndrome del túnel carpiano

E Epicondilitis lateral (codo de tenista)

Respuesta E. Dolor en el epicóndilo lateral que aumenta con la extensión resistida de la muñeca (prueba de Cozen) es una epicondilitis lateral, tendinopatía del extensor radial corto del carpo por sobreuso. Se trata con modificación de la actividad, AINE, ortesis y ejercicios excéntricos. La epitrocleítis duele en la cara medial y con la flexión resistida de la muñeca.

▶ VER CLASE 1.11.1.009

Esclerosis sistémica progresiva

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Reumatología 9.12 · Esclerosis Sistémica: Cutánea Difusa (Anti-Scl-70) vs Limitada / CREST (Anti-Centrómero) y Crisis Renal
Reumatología 9.14 · Fenómeno de Raynaud Primario vs Secundario y Capilaroscopía Periungueal

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante fenómeno de Raynaud (casi siempre el primer signo) con dedos tumefactos, esclerodactilia, úlceras digitales, reflujo y disfagia, telangiectasias o calcinosis.
- Forma difusa: piel proximal a codos y rodillas y tronco, Raynaud reciente, anti-Scl-70; riesgo de EPID (principal causa de muerte) y crisis renal. Forma limitada (CREST): distal, Raynaud de años, anticentrómero; HAP tardía.
- Raynaud secundario: inicio >30 años, asimétrico, úlceras, ANA positivos y capilaroscopía con megacapilares y áreas avasculares; el primario es simétrico, sin daño, con ANA y capilaroscopía normales.
- Crisis renal esclerodérmica: HTA maligna, falla renal aguda y esquistocitos; captopril oral en dosis crecientes. Evitar prednisona >15 mg/día (la gatilla).
- Manejo inicial: abrigo, dejar el tabaco, evitar betabloqueadores; nifedipino 10-60 mg/día para el Raynaud; omeprazol en dosis doble para el reflujo.
- Seguimiento: derivar a reumatología; espirometría con DLCO y ecocardiograma periódicos; control de presión arterial frecuente en la forma difusa.

PREGUNTAS · 9

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 31

Una paciente de 47 años, con antecedente de pirosis y dolor epigástrico de 8 meses de evolución, consulta por disfagia ilógica, de localización alta, que ha ido en aumento. Refiere fenómeno de Raynaud y al examen físico se aprecia esclerodactilia, telangiectasias en el pecho y piel de la cara indurada, sin líneas de expresión. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Acalasia esofágica

B Esclerosis sistémica

C Dermatomiositis

D Lupus eritematoso sistémico

E Enfermedad mixta del tejido conectivo

Respuesta B. El combo de Raynaud, esclerodactilia, telangiectasias y piel indurada, más un trastorno motor esofágico con pirosis, es un CREST clásico: esclerosis sistémica. La acalasia también da disfagia ilógica, pero no explica el resto del cuadro, que es de la piel y los vasos, no solo del músculo esofágico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2018 · PREGUNTA 11

Mujer de 50 años con esclerosis sistémica cutánea difusa en tratamiento con prednisona 20 mg al día por sinovitis consulta en urgencias por cefalea pulsátil intensa y mareos. Al examen físico se constata presión arterial de 205/115 mmHg. Los exámenes muestran una creatinina de 2.8 mg/dL (basal de 0.7 mg/dL) y el frotis sanguíneo revela abundantes esquistocitos con plaquetas de 85.000/mm³. ¿Cuál es el tratamiento antihipertensivo de elección indispensable para esta emergencia médica?

A Nitroprusiato de sodio en infusión continua exclusiva

B Inhibidor de la Enzima Convertidora de Angiotensina (Captopril oral en dosis crecientes)

C Metilprednisolona 1 g endovenoso por 3 días

D Amlodipino asociado a hidroclorotiazida oral

E Furosemida 80 mg endovenosa en bolo cada 6 horas

Respuesta B. El cuadro corresponde a una Crisis Renal Esclerodérmica (urgencia hipertensiva hiperreninémica con anemia hemolítica microangiopática), gatillada con frecuencia por el uso de corticoides a dosis > 15 mg/día. El tratamiento farmacológico de elección absoluta que detiene la cascada renina-angiotensina y salva la función renal es el inicio inmediato de un IECA de acción corta como Captopril oral a dosis tituladas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2020 · PREGUNTA 23

Mujer de 45 años con antecedente de fenómeno de Raynaud severo de 10 años de evolución consulta por disfagia a sólidos, pirosis retroesternal y tirantez en la piel de los dedos. Al examen se observa engrosamiento cutáneo circunscrito a dedos de manos y antebrazos distales, calcificaciones subcutáneas periarticulares en pulpejos y telangiectasias faciales. El tronco y muslos presentan piel normal. ¿Cuál es el autoanticuerpo sérico más probablemente positivo en esta paciente?

A Anticuerpos Anti-Scl-70 (Anti-Topoisomerasa I)

B Anticuerpos Anticentrómero (ACA)

C Anticuerpos Anti-dsDNA

D Anticuerpos Anti-Sm

E Anticuerpos Anti-Jo-1

Respuesta B. La paciente presenta la clínica clásica del síndrome de CREST (Calcinosis, Raynaud, Esofagopatía, Sclerodactilia, Telangiectasias), que corresponde a la forma cutánea limitada de la esclerosis sistémica (engrosamiento cutáneo restringido a manos/antebrazos distales y cara). El marcador serológico característico, presente en el 70-80% de estos pacientes, son los Anticuerpos Anticentrómero (ACA).

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2018 · PREGUNTA 33

Mujer de 38 años consulta por dolor y cambios de coloración trifásicos en los dedos de las manos desencadenados por el frío. Al examen físico se aprecia una pequeña úlcera necrótica dolorosa en el pulpejo del tercer dedo de la mano derecha y pérdida de los pliegues cutáneos dorsales en dedos (esclerodactilia). Los ANA son positivos en dilución 1:320. ¿Qué examen de consultorio o imagen permite evaluar de forma no invasiva la microcirculación periungueal para confirmar conectivopatía?

A Capilaroscopía periungueal

B Angiografía por sustracción digital de manos

C Resonancia magnética nuclear con gadolinio de muñecas

D Ecografía Doppler carotídea y vertebral bilateral

E Pletismografía de volumen por pulso arterial

Respuesta A. La capilaroscopía periungueal es la técnica no invasiva estándar de oro para estudiar el fenómeno de Raynaud y descartar esclerosis sistémica precoz. Permite visualizar directamente la morfología de las asas capilares del lecho ungueal, detectando precozmente megacapilares, microhemorragias y áreas avasculares características del patrón esclerodérmico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2020 · PREGUNTA 47

¿Cuál es el fármaco de primera línea de elección para el tratamiento del fenómeno de Raynaud sintomático recurrente que no responde adecuadamente a las medidas generales de abrigo?

A Propranolol oral en dosis ascendentes

B Bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos (Nifedipino oral)

C Ergotamina combinada con cafeína

D Prednisona oral a dosis inmunosupresoras

E Metotrexato subcutáneo semanal

Respuesta B. Los bloqueadores de los canales de calcio dihidropiridínicos (especialmente Nifedipino oral de liberación prolongada a dosis de 10 a 60 mg/día) constituyen el tratamiento farmacológico de primera elección en el fenómeno de Raynaud sintomático. Producen vasodilatación arteriolar periférica disminuyendo la frecuencia e intensidad de los espasmos vasomotores.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 54 años con antecedente de esclerosis sistémica cutánea difusa diagnosticada hace 14 meses (Anti-Scl-70 positivo), en tratamiento con metotrexato y prednisona 20 mg/día por poliartralgias. Es traída a urgencias por cefalea intensa, visión borrosa y ortopnea. Al examen físico se constata PA 210/125 mmHg, FC 98 lpm, fondo de ojo con exudados algodonosos. Piel indurada en brazos y tronco. Exámenes: creatinina plasmática 3.2 mg/dL (basal 0.8 mg/dL hace 1 mes), nitrógeno ureico 55 mg/dL. El frotis sanguíneo evidencia abundantes esquistocitos (3%), plaquetas 82.000/mm³ y LDH marcadamente elevada. **¿Cuál es el diagnóstico de esta emergencia médica, cuál fue el factor desencadenante y qué fármaco es el tratamiento de elección inmediato?**

A Crisis renal esclerodérmica gatillada por prednisona a dosis alta y tratada con Captopril oral a dosis crecientes

B Glomerulonefritis postestreptocócica tratada con penicilina benzatina intramuscular

C Púrpura trombocitopénica trombótica idiopática tratada con plasmaféresis de urgencia exclusiva

D Nefritis lúpica proliferativa difusa tratada con pulsos de ciclofosfamida endovenosa

E Estenosis bilateral de arteria renal tratada con angioplastía con balón urgente

Respuesta A. El cuadro clínico corresponde a una Crisis Renal Esclerodérmica clásica: emergencia hipertensiva maligna hiperreninémica con falla renal aguda oligoanúrica y anemia hemolítica microangiopática con esquistocitos. El uso de prednisona en dosis > 15 mg/día fue el factor desencadenante yatrogénico directo. El tratamiento de urgencia indiscutido que salva la función renal y la vida es la administración inmediata de un inhibidor de la ECA, de elección Captopril oral a dosis rápidamente crecientes,...

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 21 años, estudiante universitaria, consulta por cambios de coloración en los dedos de ambas manos al exponerse al frío invernal. Refiere que los dedos se tornan completamente blancos y fríos, luego azulados y finalmente enrojecidos y calientes al volver a una habitación temperada. Los episodios son simétricos en ambas manos. Al examen físico no se observan úlceras, cicatrices ni esclerodactilia, los pulsos radiales son simétricos y amplios. Los exámenes de laboratorio revelan hemograma, VHS y función renal normales, con anticuerpos antinucleares (ANA) negativos. La capilaroscopía periungueal muestra asas capilares finas y regulares sin dilataciones. **¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y cuál es la indicación inicial de elección?**

A Fenómeno de Raynaud primario (Enfermedad de Raynaud); educar en medidas de abrigo, evitar exposición al frío y cese de tabaco si corresponde

B Esclerosis sistémica limitada incipiente; indicar Prednisona 40 mg al día de inmediato

C Trombangiítis obliterante de Buerger; derivar a cirugía vascular para simpatectomía cervical urgente

D Lupus eritematoso sistémico; iniciar hidroxicloroquina y aspirina en dosis bajas

E Fenómeno de Raynaud secundario; iniciar anticoagulación oral con acenocumarol por seis meses

Respuesta A. El cuadro corresponde a un Fenómeno de Raynaud Primario o Enfermedad de Raynaud: mujer joven de 21 años, episodios trifásicos estrictamente simétricos en ambas manos, ausencia total de lesiones tróficas o úlceras, laboratorio con ANA negativos y capilaroscopía periungueal normal. En esta condición benigna el pilar fundamental del manejo son las medidas no farmacológicas de abrigo y educación para evitar desencadenantes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 45

Una paciente de 50 años, con antecedente de fenómeno de Raynaud frecuente, desde hace 5 años consulta por edema de los dedos y artritis de algunas articulaciones interfalángicas. Se solicitan exámenes inmunológicos que resultan ANA: positivos 1/320, en patrón anticentrómero; antiDNA: negativos; Anti Sm: negativos; Anti Ro negativo; Anti La: negativo; Factor reumatoide: negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Artritis psoriática

B Esclerosis sistémica

C Lupus

D Enfermedad mixta del tejido conectivo

E Artritis reumatoide

Respuesta B. Diagnóstico: Esclerosis sistémica (opción B). Es un CREST clásico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 16

Una paciente de 47 años consulta por pirosis y regurgitación de dos años de evolución, asociada a disfagia alta intermitente, que ha ido en aumento. Al examen físico, presenta signos vitales normales, se observan telangiectasias en el tórax y esclerosis de la piel de los dedos. Su examen cardiopulmonar y abdominal es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Acalasia esofágica

B Esclerosis sistémica progresiva

C Lupus eritematoso sistémico

D Dermatomiositis

E Polimiositis

Respuesta B. Esclerosis Sistémica Progresiva (Síndrome de CREST): Este síndrome se caracteriza por calcinosis, fenómeno de Raynaud, compromiso esofágico, esclerodactilia y telangiectasias. A largo plazo, puede desarrollar hipertensión pulmonar. El compromiso esofágico suele presentarse como disfagia ilógica y pirosis.

▶ VER CLASE 1.11.1.010 **Fibromialgia** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.23 · Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS

QUÉ HAY QUE SABER

- Fibromialgia: dolor musculoesquelético crónico generalizado (>3 meses, en 4 cuadrantes) por sensibilización central, con fatiga, sueño no reparador, colon irritable, cefalea y alteraciones cognitivas; más frecuente en mujeres de 20-55 años.
- Examen: hiperalgesia y alodinia a la presión suave, sin artritis, fuerza normal.
- Laboratorio rigurosamente normal (VHS, PCR, hemograma, CK, TSH); pedirlo para descartar hipotiroidismo, polimialgia reumática (VHS alta, >50 años), miopatías y conectivopatías.
- Pilar del tratamiento: educación en neurobiología del dolor y ejercicio aeróbico gradual de bajo impacto (caminata, natación, bicicleta); terapia cognitivo-conductual e higiene del sueño.
- Fármacos: duloxetina, pregabalina o amitriptilina en dosis bajas nocturnas. Corticoides y opioides mayores están contraindicados (ineficaces, hiperalgesia y dependencia).
- Seguimiento: derivar a equipo especializado o salud mental si es refractaria o hay comorbilidad psiquiátrica relevante.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM · MANEJO DE PRIMERA LÍNEA EN FIBROMIALGIA

Mujer de 36 años consulta por dolores osteomusculares generalizados en extremidades superiores, inferiores y columna de 10 meses de evolución. Refiere insomnio de mantención, sensación de fatiga extrema matinal, colon irritable y cefaleas tensionales frecuentes. Al examen físico no hay artritis, la fuerza muscular es 5/5 simétrica y presenta dolor a la presión suave en múltiples puntos musculotendinosos del cuerpo. La VSG (8 mm/h), la PCR, la TSH, la CPK y los ANA son normales. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea más apropiado?

A Prednisona 40 mg/día oral por 4 semanas y reposo en cama

B Educación del dolor, ejercicio aeróbico progresivo de bajo impacto y Duloxetina oral

C Sulfasalazina 1 g cada 12 horas e infiltración intraarticular con triamcinolona

D Sulfato de morfina de liberación prolongada y reposo absoluto

E Celecoxib 200 mg cada 12 horas de forma indefinida

Respuesta B. La paciente cumple criterios de Fibromialgia: dolor musculoesquelético crónico generalizado (> 3 meses en 4 cuadrantes), sueño no reparador, fatiga crónica, síntomas somáticos acompañantes y normalidad estricta de reactantes de fase aguda y enzimas musculares. El pilar fundamental de manejo es la educación, la actividad física aeróbica regular de bajo impacto (caminata, natación, bicicleta) y fármacos neuromoduladores como la Duloxetina (30-60 mg/día) o Pregabalina/Amitriptilina. Los...

PREGUNTA REAL · EUNACOM · CONTRAINDICACIONES FARMACOLÓGICAS EN FIBROMIALGIA

¿Cuál de los siguientes grupos farmacológicos se encuentra FORMALMENTE CONTRAINDICADO en el manejo a largo plazo de la Fibromialgia debido a su total ineficacia para modular el dolor nociplástico y su alto riesgo de inducir hiperalgesia paradójica y dependencia?

A Inhibidores duales de la recaptura de serotonina y noradrenalina (Duloxetina)

B Ligandos de la subunidad alfa-2-delta de canales de calcio (Pregabalina)

C Antidepresivos tricíclicos en dosis bajas (Amitriptilina)

D Corticoides sistémicos y analgésicos opioides mayores

E Analgésicos no opioides puros (Paracetamol SOS)

Respuesta D. Tanto las guías clínicas internacionales (EULAR, ACR) como las recomendaciones nacionales contraindican formalmente el uso de corticoides (prednisona) y de opioides mayores en el tratamiento de la fibromialgia. No existe evidencia de eficacia en dolor por sensibilización central, y los opioides inducen hiperalgesia paradójica mediada por receptores NMDA, dependencia física y deterioro cognitivo severo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 50

Mujer de 52 años presenta un cuadro de astenia, mialgias y artralgias generalizadas, con debilidad de las extremidades superiores. Refiere que despierta muy cansada, con dolores generalizados que limitan su actividad. Al examen físico presenta movilidad articular normal, con fuerzas conservadas, sin alteraciones sensitivas, ni artritis, pero con dolor a la palpación muscular en múltiples zonas. En sus exámenes presenta hemograma normal, VHS: 12 mm/h, PCR: 0,2 mg/dl, anticuerpos antinucleares positivos, en titulación 1/40, factor reumatoide: 26 UI/ml (VN: < 15 UI/mL) y anticuerpos anti-CCP: 13 UI/L (VN: < 8 UI/L). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Solicitar biopsia muscular

B Indicar pregabalina y ejercicios de estiramiento muscular

C Iniciar prednisona oral

D Solicitar perfil ENA (antígenos nucleares extractables)

E Iniciar metotrexato oral

Respuesta B. El cuadro clínico es una fibromialgia y los marcadores algo elevados no tienen mayor relevancia (recordar que son una trampa).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 179

Mujer de 54 años, con antecedente de síndrome de intestino irritable, que presenta un cuadro de astenia, debilidad de las extremidades superiores y mialgias. Además refiere sequedad ocular y cefalea. Al examen físico presenta movilidad articular normal, sin alteraciones de la sensibilidad, ni paresias evidentes. Presenta dolor a la presión de ambos epicóndilos y a la palpación de los músculos de la espalda. En sus exámenes presenta hemograma normal, con anticuerpos antinucleares positivos, en titulación 1/40, con factor reumatoide negativo y anticuerpos contra antígenos nucleares extractables negativos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Administrar hidrocortisona endovenosa y reevaluar en una semana

B Indicar pregabalina y ejercicios suaves de elongación

C Iniciar prednisona oral

D Solicitar biopsia de glándula salival secundaria

E Iniciar metotrexato y antiinflamatorios no esteroidales

Respuesta B. Era una fibromialgia (mialgias, astenia y dolor a la compresión de las masas musculares, sin otras alteraciones), probablemente en contexto de un trastorno de somatización. El tratamiento es con ejercicios y estabilizadores de la conducción nerviosa. Que los ANA estén positivos, no importa, porque no hay clínica de lupus. Además, están en una titulación baja (1/40), lo que se encuentra hasta en un 5% de la población sana.

▶ VER CLASE **1.11.1.011** **Hombro doloroso** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.15 · Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome del manguito rotador (la causa más común): dolor de hombro con movimientos repetitivos, peor de noche y al acostarse sobre él; duele la abducción y elevación; movilidad pasiva conservada.

- Maniobras: arco doloroso entre 60° y 120°, Neer y Hawkins (pinzamiento subacromial) y Jobe (supraespinoso). Debilidad o ascenso de la cabeza humeral sugieren rotura.
- Capsulitis adhesiva (hombro congelado): limitación activa y pasiva, fase dolorosa y luego rigidez; asociada a diabetes; corticoides y kinesioterapia intensiva.
- Descartar dolor referido (cervical, cardíaco, diafragmático) y Pancoast en fumador.
- Diagnóstico clínico; ecografía como examen de elección si se necesita imagen. Manejo: reposo relativo, AINE, frío y kinesioterapia; infiltración subacromial en casos seleccionados.
- Seguimiento completo en APS; derivar a traumatología si hay rotura completa, debilidad o falta de respuesta tras 3-6 meses.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 52 años, pintor, con dolor de hombro derecho de 3 meses que aumenta al levantar el brazo y de noche al dormir sobre ese lado. Al examen presenta arco doloroso entre 60° y 120° de abducción y pruebas de Neer y Hawkins positivas, con fuerza y rango pasivo conservados. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Capsulitis adhesiva

B Rotura masiva del manguito rotador

C Síndrome de pinzamiento subacromial (tendinopatía del supraespinoso)

D Luxación glenohumeral

E Artrosis acromioclavicular

Respuesta C. Arco doloroso entre 60° y 120°, dolor nocturno y pruebas de Neer y Hawkins positivas, con fuerza y movilidad pasiva conservadas, sugieren pinzamiento subacromial con tendinopatía del supraespinoso. La capsulitis adhesiva limita el rango pasivo y el activo, y una rotura masiva produce debilidad o incapacidad de elevar el brazo.

▶ VER CLASE 1.11.1.012 Lumbago infeccioso y tumoral

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.11 · Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar lumbago infeccioso o tumoral ante banderas rojas: fiebre, baja de peso, antecedente de cáncer, dolor nocturno o en reposo que no cede, edad >50 años, inmunosupresión, drogas endovenosas, infección reciente (urinaria, endocarditis).
- Espondilodiscitis: dolor a la percusión de la apófisis espinosa, VHS y PCR elevadas; la radiografía se altera tarde (erosión de dos platillos contiguos y del disco). TBC (mal de Pott) en inmunosuprimidos.
- Tumoral: metástasis de mama, pulmón, próstata, riñón y tiroides, o mieloma (anemia, hipercalcemia, lesiones líticas); el tumor típicamente respeta el disco.
- Examen de elección: RM con gadolinio; además hemograma, VHS, PCR, hemocultivos y estudio del primario; biopsia guiada si los cultivos son negativos.
- Urgencia: déficit neurológico o síndrome de cauda equina (anestesia en silla de montar, retención urinaria): derivación inmediata.
- Seguimiento: derivar a especialista (traumatología, infectología u oncología).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años, usuario de drogas endovenosas, presenta dolor lumbar progresivo de 3 semanas, que no cede con el reposo y es peor de noche, con fiebre intermitente. Al examen hay dolor a la percusión de la apófisis espinosa de L3. PCR 120 mg/L, VHS 85 mm/h. **¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico?**

A Radiografía de columna lumbar

B Solo analgesia y control en 6 semanas

C Densitometría ósea

D Electromiografía

E Resonancia magnética de columna lumbar con gadolinio

Respuesta E. Un lumbago con banderas rojas (fiebre, drogas endovenosas, dolor nocturno, reactantes elevados) sugiere espondilodiscitis o absceso epidural. La resonancia con gadolinio es el examen de elección por su sensibilidad precoz; la radiografía se altera tarde. Además se toman hemocultivos y, si son negativos, biopsia. Otras banderas rojas son el antecedente de cáncer y la baja de peso.

▶ VER CLASE 1.11.1.013 Lumbago mecánico

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.16 · Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico

QUÉ HAY QUE SABER

- Lumbago mecánico: la causa más frecuente de dolor lumbar; dolor que empeora con la carga y el movimiento y mejora con el reposo, tras sobreesfuerzo, con contractura paravertebral; asociado a debilidad de la musculatura axial y abdominal.
- Diagnóstico clínico tras descartar banderas rojas (fiebre, cáncer, baja de peso, trauma, edad >50, déficit neurológico, cauda equina). Sin alarma no se piden imágenes.
- Lumbociática: irradia bajo la rodilla con Lasègue positivo; L5 = dorso del pie y ortejo mayor; S1 = planta y borde lateral, con aquiliano disminuido. Mismo manejo médico inicial si no hay déficit progresivo.
- Tratamiento: AINE o paracetamol, calor local, mantenerse activo según tolerancia (el reposo en cama prolonga la incapacidad), reposo laboral breve si es necesario.
- Kinesioterapia y fortalecimiento de la musculatura cuando cede el dolor agudo; educación postural y baja de peso para prevenir recurrencias.

- Seguimiento completo: la mayoría mejora en 4-6 semanas; imágenes y derivación si persiste o aparecen banderas rojas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2017 · PREGUNTA 14

Hombre de 28 años consulta por lumbago bajo de 4 meses de evolución. ¿Cuál de las siguientes características semiológicas apoya fuertemente el origen INFLAMATORIO del dolor por sobre una etiología mecánica?

A El dolor aumenta con la deambulación y calma completamente al acostarse en la cama

B El dolor despierta al paciente en la madrugada y mejora al iniciar la actividad física matinal

C El dolor inició bruscamente tras levantar una caja pesada en el trabajo

D La rigidez matinal de la columna dura menos de 10 minutos

E El dolor empeora con la tos y la maniobra de Valsalva

Respuesta B. El dolor lumbar inflamatorio característico de las espondiloartropatías se define por presentarse en pacientes jóvenes (< 45 años), tener un inicio insidioso crónico, empeorar con el reposo en cama, despertar al paciente en la segunda mitad de la noche y MEJORAR claramente con el ejercicio y el movimiento físico. El dolor que calma con el reposo y aumenta con la carga es típicamente mecánico.

▶ VER CLASE 1.11.1.014

Lupus eritematoso sistémico

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 4.5 · Nefropatía Lúpica: Clasificación ISN/RPS y Conducta Terapéutica
Reumatología 9.8 · Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal
Reumatología 9.9 · Nefritis Lúpica y Compromiso Orgánico Mayor en LES: Clasificación, Biopsia y Terapia Inmunosupresora
Reumatología 9.10 · Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en mujer joven con eritema malar que respeta surcos nasogenianos, fotosensibilidad, úlceras orales indoloras, artritis no erosiva (Jaccoud), serositis, citopenias, nefritis o convulsiones/psicosis.
- ANA ≥1:80 es criterio de entrada obligatorio (sensibilidad >98%); anti-Sm el más específico (>99%); anti-dsDNA y C3/C4 bajos indican actividad y riesgo de nefritis. Criterios EULAR/ACR 2019: ≥10 puntos.
- Lupus por fármacos (hidralazina, procainamida, isoniazida, anti-TNF): anti-histona positivo, anti-dsDNA negativo, respeta riñón y SNC; se suspende el fármaco. Anti-Ro: lupus subagudo y bloqueo AV congénito.
- Nefritis lúpica: biopsia renal si proteinuria ≥0,5 g/24 h, sedimento activo o caída de la VFG; clases III-IV requieren inducción con pulsos de metilprednisolona + micofenolato o ciclofosfamida.
- Manejo inicial: hidroxicloroquina ≤5 mg/kg/día de por vida en todos (reduce brotes y mortalidad; control oftalmológico) y fotoprotección FPS ≥50; corticoides según actividad.
- Seguimiento: derivar a reumatología (GES); controles con hemograma, función renal, orina, complemento y anti-dsDNA.

PREGUNTAS · 9

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2024 · PREGUNTA 17

Mujer de 28 años con diagnóstico reciente de Lupus Eritematoso Sistémico leve manifestado por eritema malar y artralgias sin daño de órgano vital. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico basal que debe indicarse de forma obligatoria e indefinida para reducir brotes y disminuir la mortalidad global?

A Prednisona 60 mg al día en monoterapia permanente

B Hidroxicloroquina a dosis menor o igual a 5 mg/kg peso real al día

C Ciclofosfamida endovenosa mensual por 6 ciclos

D Metotrexato 25 mg a la semana subcutáneo sin corticoides

E Ácido acetilsalicílico 100 mg al día exclusivo

Respuesta B. En todo paciente con LES, independientemente de la severidad o si está en remisión clínica, la Hidroxicloroquina (dosis ≤ 5 mg/kg peso real/día) es la piedra angular del tratamiento que debe mantenerse de por vida. Ha demostrado reducir significativamente la frecuencia de brotes, prevenir el daño orgánico renal, disminuir eventos trombóticos y reducir la mortalidad global.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 28

Una mujer de 30 años presenta un cuadro de malestar general y artralgias de varias semanas de evolución, asociado a febrícula ocasional. Al examen físico se aprecia rash facial, úlceras orales, alopecia difusa y artritis de varias articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas de ambas manos. En sus exámenes destaca hematocrito 30%, hemoglobina 10 g/dl, leucocitos 4.000 por mm3 con 15% de linfocitos, ANA positivo en dilución 1:640, anti-DNA de doble hebra positivo en dilución 1:160, C3 60 mg/dl, C4 11 mg/dl, factor reumatoide 65 U/ml y anti-CCP negativo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Artritis reumatoide

B Púrpura trombocitopénico trombótico

C Lupus eritematoso sistémico

D Vasculitis

E Dermatomiositis

Respuesta C. Rash malar, úlceras orales, alopecia, artritis no erosiva de manos, anemia, leucopenia con linfopenia, ANA y anti-DNA positivos e hipocomplementemia: lupus eritematoso sistémico. El factor reumatoide puede ser positivo en el lupus; el anti-CCP negativo aleja la artritis reumatoide.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2018 · PREGUNTA 39

Hombre de 65 años en tratamiento crónico con Hidralazina por hipertensión arterial refractaria consulta por poliartralgias en manos, astenia y dolor torácico pleurítico de 3 semanas. Los exámenes de laboratorio revelan ANA positivos 1:320 y anticuerpos Anti-Histona positivos en títulos altos. El sedimento de orina es normal sin proteinuria, la función renal es óptima y los anticuerpos Anti-dsDNA son negativos. ¿Cuál es la conducta terapéutica inicial más apropiada?

A Iniciar pulsos de Ciclofosfamida endovenosa mensual

B Suspender de inmediato la hidralazina

C Indicar prednisona 60 mg al día por 2 años sin retirar fármacos

D Realizar biopsia renal percutánea urgente

E Prescribir metotrexato subcutáneo a dosis máximas

Respuesta B. El cuadro corresponde a un Lupus Inducido por Drogas secundario a hidralazina, respaldado por la presencia de síntomas sistémicos y articulares con respeto renal, ausencia de anti-dsDNA y presencia característica de anticuerpos anti-histona positivos. La conducta primaria y curativa consiste en la suspensión inmediata del fármaco causante, lo que conduce a la resolución progresiva del cuadro clínico en pocas semanas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2021 · PREGUNTA 14

Mujer de 32 años embarazada de 18 semanas con diagnóstico de Lupus Cutáneo Subagudo acude a control prenatal. Sus exámenes confirman anticuerpos Anti-Ro (SSA) y Anti-La (SSB) fuertemente positivos. ¿Qué complicación fetal congénita irreversible debe monitorizarse estrictamente mediante ecocardiografía fetal seriada?

A Tetralogía de Fallot

B Bloqueo auriculoventricular congénito completo

C Agenesia renal unilateral

D Coartación aórtica severa

E Transposición de grandes vasos

Respuesta B. Los anticuerpos maternos Anti-Ro (SSA) y Anti-La (SSB) de clase IgG atraviesan la barrera placentaria y pueden unirse a las células del sistema de conducción cardíaco fetal en desarrollo, provocando inflamación, necrosis y fibrosis del nodo auriculoventricular. Esto produce un Bloqueo Auriculoventricular Congénito Completo, complicación irreversible que requiere seguimiento ecocardiográfico fetal estrecho y frecuentemente marcapasos definitivo tras el nacimiento.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 74

Una paciente de 28 años consulta por artralgias generalizadas, asociadas a sensación febril y úlceras orales. En sus exámenes destaca creatinina de 1,5 mg/dL, sedimento de orina con hematuria y cilindros hemáticos y hemograma con 4.000 leucocitos por mm³. **¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?**

A Solicitar factor reumatoide

B Solicitar radiografía de tórax

C Solicitar PCR, VHS y creatinfosfoquinasa

D Solicitar anticuerpos antinucleares

E Solicitar anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos

Respuesta D. Mujer joven con artralgias, úlceras orales, leucopenia y nefritis (cilindros hemáticos): la sospecha es lupus eritematoso sistémico. El examen de tamizaje es el ANA, sensible en más de 95 %; luego anti-DNA y complemento. Los ANCA orientan a vasculitis, menos probable con úlceras orales y leucopenia.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 24 años consulta por eritema facial en mariposa que respeta surcos nasogenianos tras paseo a la playa, artralgias simétricas en muñecas y manos de 4 semanas y astenia. Al examen físico se confirma eritema malar eritematoso y úlceras orales superficiales indoloras en paladar duro. Hemograma con leucopenia de 3.200 por microlitro y trombocitopenia leve de 110.000. Sedimento de orina y creatinina normales. **¿Cuál es la conducta inicial obligatoria para confirmar el diagnóstico y qué terapia basal innegociable debe recibir?**

A Solicitar ANA por inmunofluorescencia y prescribir Hidroxicloroquina más fotoprotección estricta

B Iniciar pulsos de Ciclofosfamida endovenosa de inmediato sin esperar autoanticuerpos

C Indicar Prednisona 60 mg al día en monoterapia permanente sin exámenes serológicos

D Solicitar biopsia renal percutánea urgente y derivar a diálisis

E Prescribir Metotrexato semanal en monoterapia y suspender todo protector solar

Respuesta A. Ante la sospecha clínica de LES, el primer paso diagnóstico indispensable según los criterios EULAR/ACR 2019 es solicitar Anticuerpos Antinucleares (ANA) como criterio de entrada mandatario. En cuanto al tratamiento basal, todo paciente con diagnóstico confirmado o alta sospecha de lupus debe recibir Hidroxicloroquina a dosis ≤ 5 mg/kg peso real/día de forma indefinida, junto a fotoprotección estricta con FPS ≥ 50, medidas que reducen brotes, daño orgánico y mortalidad global.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años con hipertensión arterial en tratamiento con Hidralazina 100 mg cada 12 horas desde hace 9 meses consulta por 4 semanas de astenia, fiebre de 38 grados, artralgias simétricas en muñecas y manos y dolor torácico de tipo pleurítico. Al examen físico se ausculta frote pericárdico leve y sinovitis en muñecas. Exámenes: creatinina 0.9 mg/dL y sedimento de orina completamente normal sin proteinuria. ANA positivos 1:320, anticuerpos Anti-Histona fuertemente positivos, Anti-dsDNA negativo y complemento C3 y C4 normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es la conducta médica de elección inmediata?**

A Lupus inducido por drogas secundario a hidralazina y suspender de inmediato el fármaco

B Lupus eritematoso sistémico idiopático y hospitalizar para pulsos de ciclofosfamida

C Endocarditis infecciosa subaguda e iniciar vancomicina con gentamicina

D Artritis reumatoide seronegativa e iniciar metotrexato semanal

E Pericarditis tuberculosa e iniciar terapia cuádruple antibacteriana

Respuesta A. El cuadro clínico reúne todos los criterios clásicos de un Lupus Inducido por Drogas por hidralazina: presencia de artralgias, serositis (pleuropericarditis) y síntomas constitucionales, con respeto absoluto de la función renal y ausencia de proteinuria. El perfil inmunológico con anticuerpos Anti-Histona fuertemente positivos (>95%), Anti-dsDNA negativo y niveles normales de complemento es diagnóstico. La conducta terapéutica curativa y de primera línea es la suspensión inmediata de la hidralazina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 154

Paciente con síndrome nefrótico e hipergammaglobulinemia policlonal, complemento bajo. Diagnóstico:

A Lupus

B Amiloidosis

C Mieloma múltiple

D Hemograma y VHS

E Ecografía

Respuesta A. Diagnóstico: Lupus (opción A). El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad del tejido conectivo ANA positiva potencialmente grave.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 98

Una paciente de 23 años presenta aparición súbita de lesiones eritematosas en las mejillas, que iniciaron luego de exponerse al sol y se asocian a malestar general, caída de cabello y artralgias de manos. En el examen físico destaca eritema malar y edema de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran hemograma con hemoglobina: 9,8 g/dl, hematocrito 29%, glóbulos blancos: 3500 por mm3 y plaquetas: 90.000 por mm3, más examen de orina con proteinuria +++ y hematuria. ¿Cuál es el examen más sensible para el diagnóstico de la patología descrita?

A Factor reumatoide

B Anticuerpos anti-Ro

C Anticuerpos anti-Sm

D Anticuerpos antinucleares

E Anticuerpos antifosfolípidos

Respuesta D. Tiene un lupus eritematoso sistémico. El examen más sensible son los ANA (S = 95%). Los más específicos son los anti-DNA 2h (E = 95%, pero S = 50%; además son indicador de mal pronóstico y de actividad) y los anti-Sm (E = 99%, pero S = 25%).

▶ VER CLASE 1.11.1.015 **Monoartritis** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Reumatología 9.1 · Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial
Traumatología 12.12 · Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica

QUÉ HAY QUE SABER

- Monoartritis aguda (<6 semanas, 50% en rodilla): toda monoartritis es séptica hasta demostrar lo contrario. Causas: infección, cristales (gota, pseudogota), debut de artritis inflamatoria, hemartrosis.
- Artrocentesis diagnóstica obligatoria e inaplazable, antes del antibiótico: citoquímico, recuento celular, glucosa, Gram, cultivo y cristales con luz polarizada. Única contraindicación absoluta: celulitis en el sitio de punción.
- Líquido: no inflamatorio 200-2.000 leucocitos (artrosis); inflamatorio 2.000-50.000 (cristales, AR); séptico >50.000 con >90% PMN y glucosa <50% de la plasmática; hemorrágico (trauma, hemofilia).
- Trampas: los cristales no descartan infección (coexisten en ~5%), la pseudogota puede superar 100.000 leucocitos y un Gram negativo no descarta (sensibilidad ~50%).
- Líquido séptico: hospitalizar, hemocultivos, antibiótico EV empírico y drenaje articular. Inflamatorio con cristales: AINE, colchicina o corticoide.
- Seguimiento: derivar a traumatología (séptica) o reumatología (cristales recurrentes o artritis inflamatoria).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 69

Un paciente de 78 años consulta por gonalgia derecha intensa, que impide la marcha, asociada a aumento de volumen. Al examen físico presenta edema, eritema y aumento de la temperatura local, con signos de derrame articular. **La conducta más adecuada es:**

A Iniciar antibióticos endovenosos

B Solicitar factor reumatoide, ANA y ácido úrico

C Iniciar AINEs

D Realizar artrocentesis diagnóstica

E Solicitar resonancia magnética nuclear de rodilla

Respuesta D. En un paciente con monoartritis aguda de rodilla, la artrocentesis diagnóstica es el paso mandatorio inicial. Permite diferenciar entre artritis séptica, artropatía por microcristales (condrocalcinosis en el adulto mayor) o causa mecánica, guiando la conducta inmediata.

▶ VER CLASE 1.11.1.016 Oligoartritis

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.19 · Artritis Reactiva (Síndrome de Reiter): Tríada Clásica, Chlamydia y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Oligoartritis: compromiso de 2-4 articulaciones. Causas: espondiloartritis (reactiva, psoriásica, enteropática, espondilitis), gonococia diseminada, cristales, artritis séptica, debut de AR o LES.
- Patrón asimétrico de extremidades inferiores con dactilitis o entesitis orienta a espondiloartritis; preguntar por uretritis, diarrea, psoriasis, uveítis y enfermedad inflamatoria intestinal.
- Joven sexualmente activa con fiebre, poliartralgias migratorias, tenosinovitis y pústulas hemorrágicas: gonococia diseminada; cultivar sangre, cuello uterino, recto y faringe; ceftriaxona EV y tratar a la pareja.
- Artrocentesis de la articulación más accesible: recuento, Gram, cultivo y cristales; artritis reactiva tiene líquido inflamatorio estéril.
- Manejo inicial: AINE si se descarta infección; artritis enteropática periférica sigue la actividad intestinal (mejora al tratar el brote).
- Seguimiento: derivar a reumatología para estudio etiológico (HLA-B27, FR, anti-CCP, ANA) y tratamiento de fondo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 22 años, sexualmente activa sin preservativo, con 4 días de fiebre de 38,4 °C y poliartralgias migratorias, que evoluciona con artritis de la rodilla derecha y la muñeca izquierda, tenosinovitis dorsal de la mano izquierda y 4 pústulas hemorrágicas en las extremidades. La artrocentesis de rodilla muestra 35.000 leucocitos por mm3 con predominio polimorfonuclear y Gram sin bacterias. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y su tratamiento?**

A Artritis reactiva; AINEs

B Infección gonocócica diseminada; ceftriaxona endovenosa, estudio de otras ITS y tratamiento de la pareja

C Artritis reumatoide; metotrexato

D Gota; colchicina

E Fiebre reumática; penicilina benzatina

Respuesta B. Oligoartritis asimétrica febril en una joven sexualmente activa, con tenosinovitis y pústulas hemorrágicas, es una infección gonocócica diseminada. El Gram y el cultivo del líquido suelen ser negativos; se cultivan sangre, cuello uterino, recto y faringe. Se trata con ceftriaxona endovenosa. La artritis reactiva aparece semanas después y no da pústulas.

▶ VER CLASE 1.11.1.017 Osteoporosis

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.24 · Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica

QUÉ HAY QUE SABER

- Osteoporosis: fragilidad ósea por pérdida de masa y microarquitectura; fractura por bajo impacto (caída desde la propia altura) de cadera, vértebra, radio distal o húmero proximal establece el diagnóstico sin necesidad de densitometría.
- Densitometría (DEXA): T-score ≤−2,5 osteoporosis y −1 a −2,5 osteopenia en posmenopáusicas y hombres ≥50 años; Z-score ≤−2 en jóvenes obliga a buscar causas secundarias. FRAX: tratar si fractura mayor ≥20% o cadera ≥3%.
- Descartar causas secundarias: corticoides (la más frecuente), hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, celiaquía, mieloma, hipogonadismo; calcio, fósforo y fosfatasas alcalinas son normales en la osteoporosis.
- Basal: calcio 1.000-1.200 mg/día (preferir dieta), vitamina D3 800-2.000 UI/día (meta ≥30 ng/mL), ejercicio con carga, prevención de caídas, evitar tabaco, alcohol y benzodiacepinas.
- Alendronato 70 mg semanal en ayunas con un vaso de agua, erguido 30-60 min; contraindicado con clearance <35 mL/min (usar denosumab 60 mg SC c/6 meses, sin suspenderlo sin puente). Zoledronato 5 mg EV anual si no tolera VO.
- Seguimiento completo: control clínico y densitometría cada 2 años; derivar en osteoporosis severa con fracturas múltiples (teriparatida).

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 116

Una paciente de 66 años se realiza una densitometría ósea que muestra un T score de -3,5 DS en cadera izquierda y -2,8 en la columna lumbar a la altura de la vértebra L4. Trae además una glicemia, un perfil bioquímico y perfil lipídico, todos dentro de rangos normales. Mide 1,68 metros y pesa 49 kilos. **¿Cuál es la conducta más adecuada para esta paciente?**

A Indicar calcio y vitamina D vía oral

B Indicar una carga de vitamina D vía oral

C Administrar calcitonina intranasal

D Indicar bifosfonatos vía oral o endovenosa

E Iniciar terapia de reemplazo hormonal con estrógenos más progestágenos por vía oral

Respuesta D. T-score ≤ -2,5 en cadera y columna: osteoporosis. Tratamiento de primera línea: bifosfonato oral o EV, junto con calcio y vitamina D. Además tiene un IMC bajo (~17), otro factor de riesgo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 173

Paciente femenina con artritis reumatoide, en tratamiento con metrotexate y prednisona desde hace 4 años, es diagnosticada de diabetes mellitus, por lo que se inicia metformina como tratamiento. **¿Que examen es perentorio realizarle, como seguimiento a esta paciente?**

A Hemograma, con recuento de plaquetas

B Radiografía atlantoaxoidea

C Insulinemia

D LDH

E Densitometría ósea

Respuesta E. Cuatro años de prednisona más artritis reumatoide: dos factores de osteoporosis secundaria. Todo usuario crónico de corticoides requiere densitometría ósea.

PREGUNTA REAL · EUNACOM · INSTRUCCIONES DE TOMA DEL ALENDRONATO

Mujer de 64 años acude a control con densitometría ósea que informa un T-score de -2.8 DE en columna lumbar L1-L4 y -2.6 DE en cuello femoral. No tiene antecedentes de fracturas previas, su clearance de creatinina es de 62 mL/min y no presenta antecedentes digestivos. Se decide iniciar Alendronato 70 mg vía oral semanal. ¿Cuáles son las instrucciones farmacológicas indispensables que deben entregarse a la paciente para garantizar la absorción y prevenir la esofagitis química erosiva?

A Tomar el comprimido junto con el almuerzo acompañado de un vaso de leche para proteger la mucosa gástrica

B Tomar el comprimido en ayunas al despertar con un vaso lleno de agua pura, permaneciendo en bipedestación o sentado erguido al menos 30 a 60 minutos sin comer

C Tomar el comprimido justo antes de acostarse en la cama con jugo de naranja para acidificar el medio gástrico

D Masticar o disolver el comprimido en agua tibia junto con el suplemento de carbonato de calcio

E Ingerir el fármaco cada 12 horas con las comidas principales y mantener reposo en decúbito supino por 1 hora

Respuesta B. Los bifosfonatos orales (alendronato, risedronato) presentan una biodisponibilidad oral extremadamente baja (< 1%) y son altamente irritantes para el epitelio esofágico. Para evitar esofagitis erosiva, úlceras esofágicas graves o perforación, y garantizar su absorción, deben ingerirse estrictamente en ayunas al despertar, con un vaso completo de agua corriente pura (sin gas, leche, té ni café), el paciente debe permanecer en posición erguida (de pie o sentado) durante al menos 30 a 60 minutos...

PREGUNTA REAL · EUNACOM · TRATAMIENTO ANTIRRESORTIVO EN INSUFICIENCIA RENAL SEVERA

Mujer de 78 años con osteoporosis severa y enfermedad renal crónica avanzada en etapa 4 con una velocidad de filtración glomerular estimada de 22 mL/min presenta alto riesgo de fractura de cadera. Dado que los bifosfonatos están formalmente contraindicados con clearance de creatinina menor a 35 mL/min, ¿cuál es el fármaco antirresortivo de elección aprobado para su uso en falla renal avanzada?

A Alendronato oral en dosis reducida de 35 mg quincenales

B Ácido Zoledrónico endovenoso en infusión lenta de 2 horas

C Denosumab (anticuerpo monoclonal anti-RANKL) 60 mg subcutáneo cada 6 meses

D Calcitriol oral a dosis suprafisiológicas de 2 mcg al día

E Ibandronato oral diario sin ayuno

Respuesta C. Denosumab es un anticuerpo monoclonal completamente humano dirigido contra el ligando de RANK (RANKL). A diferencia de los bifosfonatos (que se eliminan por vía renal y son nefrotóxicos con VFG < 30-35 mL/min), el Denosumab se metaboliza por el sistema retículo endotelial como cualquier inmunoglobulina, por lo que no requiere ajuste de dosis ni está contraindicado en insuficiencia renal avanzada. Requiere monitorización estricta de calcemia por riesgo de hipocalcemia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 148

Una paciente de 66 años, que mide 1,68 metros y pesa 49 kilos, se realiza una den- sitometría ósea que muestra un T score de -3,5 DS en cadera izquierda y -2,8 en la co- lumna lumbar a la altura de la vértebra L4. Trae además una glicemia, un perfil bioquí- mico y perfil lipídico, todos dentro de rangos normales. ¿Cuál es la conducta más ade- cuada para esta paciente?

A Indicar calcio y vitamina D vía oral
B Indicar una carga de vitamina D vía oral
C Administrar calcitonina endovenosa
D Indicar bifosfonatos vía oral o endovenosa
E Iniciar terapia de reemplazo hormonal con estrógenos más progestágenos por vía oral

Respuesta D. Tiene una osteoporosis (T score menor o igual a -2,5), por lo que se debe iniciar bifosfonatos. Sin embargo también tiene que recibir vitamina D y calcio. No debería ha- ber distractores correctos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 121

Una paciente de 65 años, menopáusica hace 15 años, sufrió una fractura de muñeca derecha hace un año y recientemente sufrió una fractura de cadera derecha. La densitometría ósea muestra un T-score de -3 en la zona lumbar, -2.7 en la cadera derecha y -2.5 en la cadera izquierda. Además de indicar una adecuada ingesta de calcio y vitamina D, ¿cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?

A Alendronato 70 mg semanal
B Risedronato 150 mg semanal
C Ácido zoledrónico 5 mg cada 6 meses
D Terapia de reemplazo hormonal
E Denosumab endovenoso

Respuesta E. Tratamiento de la Osteoporosis: El tratamiento de la osteoporosis generalmente incluye la ingesta de calcio, vitamina D y bifosfonatos. No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los distintos tipos de bifosfonatos, y la principal diferencia entre ellos radica en la periodicidad con la que se administran. El alendronato se administra semanalmente, el ibandronato mensualmente, y el ácido zoledrónico semestral o anualmente. Sin embargo, en casos de osteoporosis severa,...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 37

¿Cuál es el tratamiento más adecuado para una paciente que se realiza una densitometría ósea con T score de -2,7 en las vértebras lumbares y -2,9 en la cadera izquierda?

A Bifosfonatos
B Calcitriol
C Vitamina D
D Calcio
E Raloxifeno

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Bifosfonatos (opción A). Tiene osteoporosis: T score menor a -2,5.

▶ VER CLASE **1.11.1.018** **Pelviespondilopatías seronegativas** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Reumatología 9.16 · Espondiloartritis: Concepto Unificador, HLA-B27 y Lumbago Inflamatorio vs Mecánico
Reumatología 9.17 · Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF
Reumatología 9.18 · Artritis Psoriásica (Dactilitis, Pitting Ungueal) y Artritis Asociada a EII

QUÉ HAY QUE SABER

- Espondiloartritis seronegativas: espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, reactiva y enteropática; HLA-B27 (>90% en espondilitis), entesitis como lesión primaria, FR y ANA negativos.
- Sospechar ante lumbago inflamatorio en <45 años (nocturno, mejora con ejercicio, rigidez >30 min, dolor glúteo alternante), talalgia por entesitis aquiliana, dactilitis, oligoartritis asimétrica de piernas o uveítis anterior aguda.
- Examen: Schöber modificado <5 cm, expansión torácica <2,5 cm, maniobras sacroilíacas (FABER/Patrick) positivas.
- Estudio: radiografía de pelvis (sacroilitis bilateral, cuadratura vertebral, sindesmofitos, «caña de bambú») y RM STIR en etapas precoces.
- Manejo inicial: AINE en dosis plenas continuas (naproxeno 500 mg c/12 h) y kinesioterapia con ejercicios de extensión; el metotrexato no sirve en el compromiso axial.
- Seguimiento: derivar a reumatología (anti-TNF si falla a 2 AINE, previo descarte de TBC latente y hepatitis); uveítis: derivación urgente a oftalmología.

PREGUNTAS · 11

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 72

Un paciente de 39 años, trabajador de la construcción, con IMC de 30, psoriático, consulta por dolor en la zona glútea profunda, de predominio nocturno, muy intenso y que va desapareciendo en la mañana, a medida que realiza sus actividades. El dolor inició hace 3 meses y ha aumentado. Hace 2 meses presentó una uveítis derecha. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Radiculopatía S1

B Espondiloartritis

C Espondilodiscitis

D Hernia del núcleo pulposo con compresión del plexo lumbar

E Raquiestenosis

Respuesta B. Dolor de predominio nocturno que mejora con la actividad es un dolor inflamatorio, y la uveítis refuerza el diagnóstico: espondiloartritis, con una espondilitis anquilosante clásica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2020 · PREGUNTA 29

¿Cuál es el antígeno leucocitario humano (HLA) que presenta una asociación genética superior al 90% con la Espondilitis Anquilosante y que se encuentra frecuentemente ligado a las espondiloartritis seronegativas?

A HLA-DR4

B HLA-B27

C HLA-DR3

D HLA-DQ2

E HLA-B51

Respuesta B. El alelo HLA-B27 (complejo mayor de histocompatibilidad clase I) presenta una asociación fuertísima con las espondiloartritis seronegativas, encontrándose positivo en más del 90% de los pacientes con Espondilitis Anquilosante y en el 50-80% de las artritis reactivas y espondiloartritis axiales. El HLA-DR4 se asocia a Artritis Reumatoide y el HLA-B51 a Enfermedad de Behçet.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2023 · PREGUNTA 07

Hombre de 24 años consulta por dolor en talón derecho al apoyar el pie en las mañanas y dolor lumbar bajo intermitente que mejora al correr. Al examen físico destaca dolor exquisito a la palpación de la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo derecho, sin signos de infección cutánea. ¿Cuál es el sustrato anatomopatológico primario de esta manifestación periférica típica de las espondiloartritis?

A Sinovitis proliferativa con formación de pannus erosivo articular

B Entesitis (inflamación de la inserción ósea del tendón)

C Tromboflebitis superficial de la vena safena menor

D Neuroma de Morton interdigital

E Osteocondritis disecante subastragalina

Respuesta B. La entesitis es la inflamación de las entesis (sitios anatómicos de inserción de tendones, ligamentos, aponeurosis o cápsulas articulares en el hueso). Constituye la lesión elemental primaria y distintiva de las espondiloartritis. La talalgia por entesitis del tendón de Aquiles o de la fascia plantar en el calcáneo es una de las quejas periféricas más típicas en adultos jóvenes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2018 · PREGUNTA 22

Hombre de 24 años consulta por dolor lumbar de 6 meses de evolución que empeora con el reposo en cama y despierta al paciente en la madrugada, asociado a rigidez matinal de 2 horas. Al examen físico se realiza el Test de Schöber modificado: la distancia inicial de 10 cm entre las marcas de la columna lumbar aumenta únicamente a 12.5 cm a la flexión anterior forzada del tronco. ¿Cómo se interpreta este resultado semiológico?

A Test normal que descarta patología de columna lumbar

B Test patológico que indica limitación objetiva de la flexión de la columna lumbar

C Test patológico que indica hiperlaxitud ligamentosa de columna

D Test que indica hernia discal lumbar con radiculopatía L5 activa

E Test no válido que debe repetirse en posición sedente

Respuesta B. En el Test de Schöber modificado, la distancia entre las dos marcas cutáneas lumbares debe incrementarse en al menos 5 cm (alcanzando ≥ 15 cm en total) durante la flexión anterior forzada. Un aumento de solo 2.5 cm (total 12.5 cm) es francamente patológico y demuestra rigidez y limitación objetiva de la movilidad lumbar, hallazgo cardinal en la espondilitis anquilosante.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2022 · PREGUNTA 33

Hombre de 30 años con diagnóstico confirmado de Espondilitis Anquilosante axial severa no presenta mejoría de sus síntomas ni de su rigidez tras 3 meses de tratamiento continuado con Naproxeno 500 mg cada 12 horas y posterior ensayo con Indometacina 75 mg cada 12 horas. Mantiene un índice de actividad BASDAI de 5.8. No tiene compromiso articular periférico. ¿Cuál es el tratamiento de segunda línea indicado para su compromiso axial?

A Iniciar Metotrexato 20 mg por semana oral con ácido fólico

B Iniciar Terapia Biológica con un inhibidor del TNF-alfa (ej. Adalimumab o Infliximab)

C Prescribir Prednisona 40 mg al día de forma permanente

D Indicar Sulfasalazina 3 gramos al día oral en monoterapia

E Hidroxicloroquina 400 mg al día más reposo absoluto

Respuesta B. En la Espondilitis Anquilosante con compromiso axial puro refractario a AINEs a dosis plenas, los FARME convencionales sintéticos como Metotrexato o Sulfasalazina han demostrado ser totalmente ineficaces. La indicación formal de segunda línea según las guías internacionales y canasta GES es el inicio de Terapia Biológica con inhibidores del TNF-alfa (o inhibidores de IL-17), previo tamizaje de tuberculosis latente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2024 · PREGUNTA 29

¿Cuál es el hallazgo radiológico cardinal en la columna vertebral que define la fase avanzada de anquilosis intersomática completa en la Espondilitis Anquilosante?

A Osteofitos marginales horizontales asimétricos

B Sindesmofitos óseos verticales delgados que fusionan cuerpos vertebrales en caña de bambú

C Aplastamientos vertebrales bicóncavos en pez

D Erosiones líticas expansivas en sacabocado

E Espondilolistesis ístmica bilateral L5-S1

Respuesta B. En la espondilitis anquilosante avanzada, la osificación progresiva del anillo fibroso del disco intervertebral genera sindesmofitos óseos marginales delgados de orientación estrictamente vertical que unen los cuerpos vertebrales contiguos, produciendo la clásica imagen radiológica de "columna en caña de bambú" (bamboo spine). Los osteofitos de la artrosis son gruesos y horizontales.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 26 años, administrativo, consulta por dolor lumbar bajo y en ambas nalgas de 5 meses de evolución. Refiere que el dolor es mucho más intenso en las mañanas al despertar, acompañado de rigidez de columna que dura más de 1 hora y que le dificulta calzarse los zapatos. El dolor lo despierta a las 4:00 AM, obligándolo a pasear por la habitación. Conforme camina y avanza el día, el dolor disminuye significativamente. Ha tomado Ibuprofeno 400 mg de forma ocasional con alivio casi inmediato de los síntomas. Al examen físico se constata limitación dolorosa de la flexión anterior de tronco y dolor a la palpación de articulaciones sacroilíacas. **¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Lumbago inflamatorio por sospecha de espondiloartritis; indicar AINEs a dosis plenas, solicitar radiografía de pelvis para evaluar sacroilíacas y derivar a reumatología

B Lumbago mecánico común por discopatía; indicar reposo absoluto en cama por 14 días y relajantes musculares

C Artritis reumatoide seronegativa; iniciar metotrexato oral 15 mg semanales y solicitar factor reumatoide

D Espondilodiscitis infecciosa piógena; hospitalizar de inmediato para hemocultivos y resonancia con contraste urgente

E Fibromialgia primaria; derivar a salud mental y descartar dolor lumbar con radiografía simple

Respuesta A. El paciente cumple todos los criterios de dolor lumbar inflamatorio: edad menor a 45 años (26 años), curso crónico > 3 meses (5 meses), rigidez matinal prolongada (> 1 hora), dolor nocturno que despierta en la madrugada obligándolo a caminar, mejoría franca con el ejercicio, dolor en nalgas (sacroilitis) y excelente respuesta a AINEs. La conducta indicada es mantener AINEs en dosis plenas continuas, solicitar radiografía de pelvis centrada en sacroilíacas y derivar a reumatología.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 25 años consulta por dolor lumbar bajo y rigidez matinal de 90 minutos de 8 meses de evolución, que empeora tras descansar en cama y lo despierta de madrugada. Al examen físico el test de Schöber modificado muestra un aumento de solo 2 cm (de 10 a 12 cm a la flexión anterior forzada) y la expansión torácica es de 2.0 cm. La radiografía de pelvis muestra esclerosis subcondral bilateral simétrica con borramiento parcial del espacio articular en ambas sacroilíacas (sacroilitis bilateral grado 2). El factor reumatoide y los ANA son negativos. **¿Cuál es el diagnóstico clínico definitivo y cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea que debe indicarse de inmediato?**

A Espondilitis Anquilosante; iniciar AINEs a dosis plenas continuas (ej. Naproxeno 500 mg cada 12 horas) y kinesioterapia de columna

B Artritis reumatoide seronegativa; iniciar Metotrexato 15 mg semanales más ácido fólico

C Lumbago mecánico postural; prescribir paracetamol a demanda y reposo en cama por dos semanas

D Espondilitis Anquilosante refractaria; iniciar Adalimumab subcutáneo sin ensayar AINEs

E Hernia discal lumbar bilateral; derivar a neurocirugía para laminectomía descompresiva urgente

Respuesta A. El paciente cumple plenamente los Criterios de Nueva York modificados para Espondilitis Anquilosante: criterios clínicos (dolor lumbar inflamatorio crónico, test de Schöber patológico con aumento menor a 5 cm y expansión torácica reducida menor a 2.5 cm) sumado al criterio radiológico mandatorio de sacroilitis bilateral grado ≥ 2 en radiografía simple. El tratamiento farmacológico de primera línea son los AINEs a dosis plenas continuas junto a un programa de kinesioterapia de columna.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 125

Un paciente de 23 años presenta dolor lumbar, irradiado a ambas piernas, de 2 años de evolución, y que suele ser mayor en la noche. Además presenta dolor torácico, que aumenta con los movimientos respiratorios. El dolor cede parcialmente con AINEs. Refiere un cuadro de artritis de rodilla derecha, autolimitado, hace un año. Al examen físico presenta restricción a los movimientos torácicos y a limitación de la flexión lumbar. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A Factor reumatoide

B Resonancia magnética de articulaciones sacroiliacas

C TAC de columna lumbosacra

D Radiografía de tórax

E Hemograma y VHS

Respuesta B. Es una espondilitis anquilosante. Si bien el mejor examen es la resonancia magnética nuclear de sacroiliacas, se suele pedir una radiografía de sacroiliacas, como primer examen, ya que tiene buen rendimiento en los pacientes con mucho tiempo con síntomas. El FR está negativo. También sirve de apoyo el HLA-B27

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 110

Paciente 27 años con espondilopatia o era sacroileítis?'?, cual es el tratamiento inicial:

A Ibuprofeno

B Prednisona

C Paracetamol (porque no puede paracetamol??)

D Amoxicilina

E Omeprazol

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Ibuprofeno (opción A).

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 97

Un paciente de 23 años consulta por dolor lumbar y en la zona glútea, de 1 año de evolución, que es mayor en las mañanas y al dormir y que va cediendo a medida que realiza sus actividades durante el día. Además, ha presentado dolor y aumento de volumen de la rodilla derecha, que luego desapareció espontáneamente. Al examen físico tiene placas descamativas en las rodillas, depresiones ungueales, dolor a la compresión prueba de Lasegue negativa, prueba de Schöbber 2 cm. En sus exámenes destaca ANA negativos y factor reumatoide, dentro de límites normales. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A Radiografía de columna lumbosacra

B Tomografía de columna dorsolumbar

C Radiografía de tórax

D Resonancia magnética nuclear de articulaciones sacroilíacas

E ANCA, C3 y C4

Respuesta A. Tiene clínica de una pelviespondiloartropatía (PEA). Además, las lesiones cutáneas orientan fuertemente a artritis psoriática. La RMN es el mejor examen para las PEA, pero La radiografía simple de sacroilíacas (ej. lumbosacra) suele ser el primer examen a solicitar, dado que es barato, está disponible y entrega mucha información. En la artritis psoriática la RMN es muy importante y debe solicitarse, pero la radiografía sigue siendo el primer examen. Las pruebas serológicas no sirven, ya que resultan negativas.

▶ VER CLASE `1.11.1.019` **Poliartritis** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Reumatología 9.5 · Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) y Enfermedad de Still del Adulto
Reumatología 9.6 · Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares

QUÉ HAY QUE SABER

- Poliartritis: inflamación de ≥5 articulaciones. Aguda (<6 semanas): virales (parvovirus B19, rubéola, hepatitis B y C), gonococia, fiebre reumática, Still. Crónica: AR, LES, artritis psoriásica, gota poliarticular.
- Patrón orienta: simétrica de MCF, IFP y muñecas con rigidez >1 h = AR; IFD con nódulos de Heberden y rigidez breve = artrosis nodal (no inflamatoria); IFD con dactilitis y psoriasis = psoriásica.
- Estudio inicial: hemograma, VHS/PCR, FR, anti-CCP, ANA, ácido úrico, función renal y hepática, orina y radiografía de manos y pies; artrocentesis si hay derrame accesible.
- En <16 años con artritis >6 semanas: artritis idiopática juvenil (GES); la forma oligoarticular con ANA positivos exige control con lámpara de hendidura (uveítis silente). Fiebre en agujas, rash asalmonado y ferritina muy alta: Still.
- Manejo inicial: AINE o paracetamol; evitar corticoides antes de definir el diagnóstico salvo indicación del especialista.
- Seguimiento: derivar a reumatología (GES de AR ante poliartritis de manos >6 semanas).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 32 años, educadora de párvulos, consulta por dolor y aumento de volumen simétrico de muñecas y articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales de ambas manos, de 6 días de evolución, con rigidez matinal y un rash reticular leve en los muslos. Dos semanas antes, varios niños de su sala tuvieron fiebre y las mejillas muy rojas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar metotrexato semanal por sospecha de artritis reumatoide

B AINEs y control clínico, porque probablemente es una poliartritis viral por parvovirus B19 que se autolimita

C Prednisona 1 mg/kg/día

D Cloxacilina endovenosa

E Alopurinol oral

Respuesta B. Una poliartritis simétrica aguda, de menos de 6 semanas, tras contacto con niños con eritema infeccioso, orienta a parvovirus B19, que suele autolimitarse en semanas. Se maneja con AINEs y observación; la IgM para parvovirus confirma. Iniciar metotrexato es prematuro: antes de 6 semanas una poliartritis puede ser viral y transitoria.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 63 años consulta por dolor en ambas manos de 3 años, que empeora con el uso. Tiene rigidez matinal de 15 minutos. Al examen presenta nódulos duros en las interfalángicas distales y proximales de varios dedos, sin sinovitis de metacarpofalángicas ni de muñecas. La VHS y la PCR son normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Artritis reumatoide

B Artritis psoriásica

C Artrosis nodal de manos

D Lupus eritematoso sistémico

E Gota tofácea

Respuesta C. Compromiso de interfalángicas distales y proximales con nódulos óseos de Heberden y Bouchard, rigidez matinal breve y reactantes normales es artrosis nodal de manos. La artritis reumatoide afecta metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y muñecas, respeta las distales y da rigidez matinal mayor de 1 hora.

▶ VER CLASE 1.11.1.020 Polimiositis, dermatomiositis

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.13 · Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto

QUÉ HAY QUE SABER

- Miopatía inflamatoria: debilidad proximal simétrica de cinturas (dificultad para subir escaleras, levantarse o peinarse) de semanas-meses, con fuerza distal conservada y respeto de músculos oculares (diferencia con miastenia).
- Dermatomiositis: eritema en heliotropo (párpados violáceos con edema) y pápulas de Gottron en nudillos; polimiositis sin lesiones cutáneas.
- Laboratorio: CK elevada 10-50 veces, transaminasas y LDH de origen muscular; anti-Jo-1 (síndrome antisintetasa: EPID, manos de mecánico, Raynaud). Confirmación con EMG, RM muscular y biopsia.
- Complicaciones: EPID, disfagia orofaríngea (riesgo de aspiración), miocarditis. En adultos (sobre todo >50 años) tamizaje de neoplasia oculta (25-30%): TAC de tórax, abdomen y pelvis, mamografía, evaluación ginecológica y digestiva.
- Diferencial: miopatía por estatinas, hipotiroidismo (TSH), miopatía por cuerpos de inclusión, polimialgia reumática (CK normal).
- Manejo inicial: derivar a reumatología; tratamiento con prednisona 1 mg/kg/día y ahorradores (metotrexato o azatioprina); pulsos o inmunoglobulina si hay disfagia o compromiso respiratorio.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 109

Un paciente de 82 años, con antecedente de diabetes y enfermedad coronaria, en tratamiento farmacológico con metformina 1 gramo cada 8 horas, glibenclamida 10 mg cada 12 horas, aspirina 100 mg al día y atorvastatina 40 mg al día, presenta un cuadro de mialgias generalizadas, asociadas a debilidad muscular, mayor en la cintura escapular y los muslos. Se solicitan exámenes, entre los que destacan CK: 1.320 UI/L, GOT: 128 UI/L y GOT: 133 UI/L. **El diagnóstico más probable es:**

A Miopatía diabética

B Polineuropatía diabética

C Miopatía por estatinas

D Polimiositis

E Polimialgia reumática

Respuesta C. Usuario de atorvastatina con mialgias proximales, debilidad y CK elevada varias veces sobre lo normal: miopatía por estatinas (miositis). Exige suspender la estatina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2017 · PREGUNTA 24

Mujer de 56 años consulta por debilidad proximal en cuatro extremidades y erupción cutánea de 6 semanas. Al examen físico se aprecian pápulas eritematovioláceas sobre las articulaciones metacarpofalángicas de ambas manos (pápulas de Gottron) y coloración violácea en párpados superiores. La CPK plasmática es de 3.800 U/L. Tras iniciar tratamiento con prednisona a dosis plenas, ¿qué estudio médico complementario es INDISPENSABLE y prioritario realizar?

A Cintigrama óseo para descartar metástasis osteoblásticas difusas

B Tamizaje exhaustivo de neoplasia oculta mediante TAC toracoabdominal, mamografía y evaluación ginecológica

C Punción lumbar para estudio citoquímico de líquido cefalorraquídeo

D Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía urgente

E Biopsia de médula ósea para descartar mielofibrosis primaria

Respuesta B. En adultos con dermatomiositis (especialmente mayores de 50 años), hasta un 25-30% de los casos corresponden a un síndrome paraneoplásico secundario a un cáncer oculto (cáncer de ovario, mama, pulmón, colon, etc.). Por tanto, además de confirmar la miopatía e iniciar inmunosupresión, es prioritario y mandatorio realizar un cribado oncológico completo e intensivo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2022 · PREGUNTA 27

Hombre de 48 años con diagnóstico de miopatía inflamatoria presenta debilidad muscular proximal moderada y disnea de esfuerzo progresiva. La radiografía y el TAC de tórax confirman una neumopatía intersticial difusa de patrón reticular bilateral. Al examen destaca fenómeno de Raynaud, artralgias y manos con hiperqueratosis y fisuras descamativas dolorosas en los bordes laterales de los dedos (manos de mecánico). ¿Cuál es el autoanticuerpo sérico más probablemente positivo en este paciente?

A Anticuerpos Anti-Jo-1 (Anti-histidil-tRNA sintetasa)

B Anticuerpos Anticentrómero

C Anticuerpos Anti-Smith

D Anticuerpos Anti-dsDNA

E Anticuerpos Anti-Histona

Respuesta A. La constelación clínica de miopatía inflamatoria + enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) + fenómeno de Raynaud + manos de mecánico + artritis no erosiva define el Síndrome Antisintetasa, cuyo marcador serológico patognomónico es el anticuerpo Anti-Jo-1 (anti-tRNA sintetasa).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 58 años sin antecedentes previos consulta por debilidad progresiva en hombros y muslos de 2 meses, con gran dificultad para subir escaleras y peinarse. Al examen físico destaca fuerza 3/5 en cuádriceps y deltoides con fuerza distal 5/5. Los párpados superiores muestran eritema violáceo con edema blando (heliotropo), y en el dorso de las articulaciones metacarpofalángicas de ambas manos se observan pápulas violáceas descamativas (Gottron). La CPK es de 4.200 U/L y las transaminasas están elevadas. **¿Cuál es el diagnóstico clínico, cuál es el tratamiento farmacológico inicial y qué estudio complementario mandatario debe solicitarse?**

A Dermatomiositis, iniciar Prednisona 1 mg/kg/día y realizar tamizaje exhaustivo de neoplasia oculta

B Miastenia Gravis, iniciar piridostigmina oral y solicitar anticuerpos anti-MuSK

C Polimialgia reumática, indicar Prednisona 15 mg al día sin otros exámenes

D Lupus eritematoso sistémico, iniciar hidroxicloroquina ambulatoria exclusiva

E Esclerosis lateral amiotrófica, derivar a cuidados paliativos neurológicos

Respuesta A. El cuadro clínico reúne los signos patognomónicos de la Dermatomiositis: debilidad muscular proximal simétrica, elevación masiva de CPK (con transaminasas de origen muscular) y las lesiones cutáneas cardinales: eritema en heliotropo y pápulas de Gottron. El tratamiento de primera línea son los corticoides a dosis plenas (Prednisona 1 mg/kg/día). En una mujer adulta de 58 años es estrictamente obligatorio realizar un tamizaje exhaustivo de neoplasia oculta (TAC de tórax, abdomen y pelvis,...

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 104

Un hombre de 68 años, diabético mal controlado, consulta por mialgias generalizadas de 2 semanas de evolución, mayores en los muslos, asociadas a debilidad, mayor en la cintura pélvica y astenia. En el último tiempo refiere dificultades para ponerse de pie, desde una silla o desde la cama. Al examen físico se objetiva debilidad muscular de predominio proximal, sin alteraciones sensitivas. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma con hemoglobina: 12,1 g/dl, hematocrito: 37%, blancos: 7.000 por mm3, plaquetas: 250.000 por mm3, VHS: 10 mm/hora. Además, trae glicemia: 150 mg/dl, creatinfosfoquinasa: 1.760 UI/L, LDH: 1.050 UI/L, PCR: 4,3 mg/L, SGOT: 250 UI/L, SGPT: 170 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Polimiositis

B Polimialgia reumática

C Polineuropatía diabética

D Miopatía por cuerpos de inclusión

E Síndrome de Guillain Barré

Respuesta A. La debilidad proximal orienta a miopatía. La elevación de la CK y de los parámetros inflamatorios (PCR) orienta a polimiositis. La polimialgia reumática también puede tener una clínica similar e incluso elevar las CK, pero tiende a elevar mucho la VHS (la polimiositis también puede hacerlo) y, lo más importante, no tiene debilidad en el examen físico (aunque sí puede tener sensación de debilidad). La miopatía por cuerpos de inclusión también es una miopatía inflamatoria y puede tener una...

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 105

Un paciente de 71 años, con antecedente de diabetes, hipertensión arterial y lumbago crónico, en tratamiento con hipoglicemiantes orales, atorvastatina y losartán, presenta un cuadro de 1 mes de debilidad de las 4 extremidades, mayor en los muslos, asociadas a mialgias, que en el último tiempo le han dificultado la marcha. Al examen físico se constata paresia M4 de ambas extremidades inferiores, mayor en los cuádriceps, sin alteraciones sensitivas ni focalidad neurológica. Se solicitan exámenes que muestran hemoglobina: 12,1 g/dl, hematocrito: 33%, blancos: 6.200 por mm3, plaquetas: 180.000 por mm3, VHS: 50 mm/hora, SGOT: 210 UI/L, SGPT: 110 UI/L, CPK: 3.760 UI/L, LDH: 1.050 UI/L, PCR: 4,3 mg/L y hemoglobina glicosilada: 7,5%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Miopatía por estatinas
B Polimialgia reumática
C Polimiositis
D Miositis por cuerpos de inclusión
E Raquiestenosis medular

Respuesta C. Diagnóstico: Polimiositis (opción C). Es otra polimiositis clásica, en especial por el marcado aumento de las CPK y la debilidad. La polimiositis y dermatomiositis son miopatías autoinmunes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 104

Una paciente de 58 años, con antecedente de cáncer de mama, tratado con cirugía y radioterapia hace un año, consulta astenia y debilidad de las 4 extremidades. Al exa- men físico presenta edema y eritema palpebral, asociado a aumento de volumen en el brazo derecho. Al examen neurológico se constata la tetraparesia, con reflejos osteoten- díneos normales, sin alteraciones en el tono muscular, ni signos focales. El diagnóstico más probable es:

A Síndrome de Guillain Barré
B Miastenia gravis
C Polimialgia reumática
D Dermatomiosistis
E Vasculitis

Respuesta D. Es una dermatomiositis clásica: compromiso de párpados, mialgias, debilidad. Re- cordar que suele ser paraneoplásica, por lo que además se debe sospechar recidiva del cáncer.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 131

Un hombre de 78 años consulta por debilidad de las extremidades inferiores, que le dificulta realizar movimientos como pararse de una silla o subir escaleras. Al examen físico tiene paresia de las extremidades inferiores, la sensibilidad es normal y no tiene alteración de los reflejos osteotendíneos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Polimiositis
B Hipotiroidismo
C Déficit de vitamina B12
D Distrofia muscular progresiva
E Raquiestenosis

Respuesta A. Tiene clínica de una miopatía: debilidad proximal, sin alteraciones sensitivas ni de los reflejos. B, C y E afectan los reflejos y tienen otros síntomas. La raquiestenosis principalmente tiene dolor al caminar, más afectación de las raíces comprometidas. D afecta más a niños, ya que es genética.

▶ VER CLASE `1.11.1.021` **Síndrome antifosfolípidos**

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Hematología 8.23 · Trombofilias Hereditarias (Factor V Leiden, Protrombina G20210A) y SAF: Cuándo Estudiar y Manejo
Reumatología 9.11 · Síndrome Antifosfolípido (SAF): Criterios de Sydney, Trombosis Vascular y Manejo Obstétrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante trombosis venosa o arterial en joven sin factores de riesgo, trombosis recurrente o en sitios atípicos, y morbilidad obstétrica: ≥3 abortos consecutivos <10 semanas, muerte fetal ≥10 semanas o parto <34 semanas por preeclampsia o insuficiencia placentaria.
- Pistas de laboratorio: TTPA prolongado que no corrige con plasma normal (anticoagulante lúpico, paradójicamente protrombótico), VDRL falso positivo, trombocitopenia leve; livedo reticularis y endocarditis de Libman-Sacks.
- Diagnóstico: anticoagulante lúpico, anticardiolipinas o anti-β2-glicoproteína I positivos en 2 determinaciones separadas por ≥12 semanas; puede asociarse a LES.
- Trombosis: heparina y luego acenocumarol o warfarina con INR 2-3 de por vida; los anticoagulantes orales directos están contraindicados.
- Embarazo: aspirina 100 mg/día + enoxaparina profiláctica (dosis terapéutica si hubo trombosis); cumarínicos contraindicados (teratógenos). Evitar anticonceptivos con estrógenos y tabaco.
- Seguimiento: derivar a reumatología o hematología; el SAF catastrófico (≥3 órganos en <1 semana) es manejo de UCI.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2017 · PREGUNTA 41

Mujer de 31 años con antecedente de trombosis venosa profunda iliofemoral derecha hace 2 años y dos pérdidas reproductivas previas es diagnosticada de Síndrome Antifosfolípido con triple positividad serológica (anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y anti-beta-2-glicoproteína I positivos confirmados). Actualmente consulta a control hematológico. ¿Cuál es el tratamiento antitrombótico a largo plazo recomendado?

A Rivaroxabán 20 mg al día oral en monoterapia

B Antagonistas de vitamina K (Acenocumarol o Warfarina) con meta de INR entre 2.0 y 3.0 indefinido

C Ácido acetilsalicílico 100 mg al día en monoterapia

D Apixabán 5 mg cada 12 horas por 6 meses y suspender

E Dabigatrán 150 mg cada 12 horas asociado a clopidogrel

Respuesta B. En pacientes con Síndrome Antifosfolípido trombótico (y en especial con triple positividad serológica), el tratamiento estándar de oro a largo plazo es la anticoagulación oral indefinida con antagonistas de vitamina K (Acenocumarol o Warfarina) con meta de INR entre 2.0 y 3.0. Los anticoagulantes orales directos (DOACs como rivaroxabán o apixabán) están formalmente contraindicados debido al ensayo TRAPS, que demostró un incremento inaceptable de trombosis arteriales recurrentes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2019 · PREGUNTA 27

Mujer de 30 años con antecedente de dos abortos espontáneos tempranos y una muerte fetal intrauterina a las 24 semanas presenta confirmación de Síndrome Antifosfolípido mediante anticardiolipinas IgG positivas a títulos altos en dos determinaciones separadas por 14 semanas. Actualmente consulta con 6 semanas de gestación confirmada. No tiene antecedentes de trombosis venosa ni arterial. ¿Cuál es el esquema farmacológico indicado para el manejo de su embarazo?

A Warfarina ajustada a INR 2.0 – 3.0 durante todo el embarazo

B Ácido acetilsalicílico 100 mg al día más Enoxaparina 40 mg al día subcutánea

C Prednisona 40 mg al día vía oral sin anticoagulantes

D Reposo absoluto en cama sin fármacos antitrombóticos

E Inmunoglobulina endovenosa mensual exclusiva

Respuesta B. En el Síndrome Antifosfolípido obstétrico (sin antecedente de trombosis vascular previa), el esquema terapéutico estándar para asegurar la viabilidad gestacional y prevenir la pérdida fetal es la combinación sinérgica de Ácido Acetilsalicílico a dosis bajas (100 mg/día) asociado a Heparina de Bajo Peso Molecular a dosis profiláctica (Enoxaparina 40 mg/día SC), manteniéndose la heparina hasta 6 semanas postparto. La warfarina está contraindicada en la gestación por teratogenia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2024 · PREGUNTA 36

¿Cuál de los siguientes criterios obstétricos clasifica formalmente como criterio clínico para Síndrome Antifosfolípido según los criterios internacionales de Sydney?

A Un único aborto espontáneo a las 6 semanas de gestación

B Una muerte fetal inexplicable de feto morfológicamente normal a las 22 semanas

C Parto prematuro a las 36 semanas secundario a rotura prematura de membranas

D Dos pérdidas gestacionales del primer trimestre no consecutivas

E Embarazo ectópico tubario intervenido quirúrgicamente

Respuesta B. Los criterios de Sydney definen tres escenarios de morbilidad obstétrica en SAF: 1) Una o más muertes inexplicables de fetos morfológicamente normales a partir de las 10 semanas de gestación; 2) Uno o más partos prematuros de neonatos normales antes de las 34 semanas debido a preeclampsia severa, eclampsia o insuficiencia placentaria; y 3) Tres o más abortos espontáneos consecutivos inexplicados antes de las 10 semanas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 29 años, cursando embarazo de 8 semanas confirmado por ecografía con embrión vivo y latidos cardiofetales presentes. Sus antecedentes revelan 3 abortos espontáneos consecutivos del primer trimestre (a las 7, 8 y 9 semanas) en los últimos 3 años, sin antecedentes de trombosis vascular. El estudio inmunológico solicitado hace 3 meses mostró Anticoagulante Lúpico positivo y anticuerpos anticardiolipina IgG en 58 GPL (positivo alto). Se repitieron los exámenes a las 14 semanas de intervalo, confirmándose la positividad persistente de ambos marcadores. **¿Cuál es el esquema farmacológico indicado para asegurar la viabilidad gestacional y prevenir la pérdida fetal?**

A Ácido acetilsalicílico 100 mg al día más Enoxaparina 40 mg al día subcutánea

B Warfarina oral ajustada a INR entre 2.0 y 3.0 durante todo el embarazo

C Rivaroxabán 20 mg al día oral en monoterapia

D Prednisona 40 mg al día vía oral sin heparina

E Reposo absoluto en cama sin fármacos antitrombóticos

Respuesta A. La paciente cumple los criterios clasificatorios de Sydney para Síndrome Antifosfolípido Obstétrico: criterio clínico (≥ 3 abortos consecutivos < 10 semanas) más criterio serológico confirmado en dos ocasiones con intervalo > 12 semanas (anticoagulante lúpico y anticardiolipinas IgG a títulos altos). El esquema estándar de elección consiste en la asociación de Ácido Acetilsalicílico a dosis bajas (100 mg/día) más Heparina de Bajo Peso Molecular a dosis profiláctica (Enoxaparina 40 mg/día SC),...

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 31 años con trombosis venosa profunda iliofemoral izquierda no provocada, confirmada por eco-Doppler. Antecedente de dos pérdidas fetales a las 18 y 22 semanas, con fetos morfológicamente normales, y un aborto a las 8 semanas. No usa anticonceptivos, no ha viajado ni tenido cirugías. TP normal, TTPK 52 s (control 30 s) que no corrige con la mezcla 1:1. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Heparina de bajo peso molecular y rivaroxabán como anticoagulante de mantención

B Medir proteína C, S y antitrombina hoy, antes de anticoagular

C HBPM con puente a acenocumarol (INR 2–3) y anticuerpos antifosfolípidos, a repetir en 12 semanas

D Plasma fresco congelado para corregir el TTPK antes de anticoagular

E Estudio de factores VIII y IX por sospecha de hemofilia

Respuesta C. Trombosis no provocada + muertes fetales desde la semana 10 + TTPK largo que no corrige con mezcla: anticoagulante lúpico y alta sospecha de SAF. Se anticoagula con HBPM puenteada a acenocumarol (INR 2–3) y se piden anticoagulante lúpico, anticardiolipina y anti-β2GP1, a confirmar a las 12 semanas. Los DOAC están contraindicados; el estudio funcional no se hace en fase aguda.

▶ VER CLASE 1.11.1.022

Síndrome de Sjögren

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.15 · Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante síndrome sicca: xeroftalmia (arenilla, ardor) y xerostomía (necesidad de líquidos para tragar, caries cervicales), con aumento parotídeo; más frecuente en mujeres de mediana edad. Puede ser primario o secundario a AR o LES.
- Confirmación: test de Schirmer <5 mm en 5 minutos, anti-Ro (SSA) y anti-La (SSB), ANA y FR positivos; biopsia de glándula salival menor (≥1 foco linfocitario/4 mm²) como patrón de oro.
- Extraglandulares: poliartritis no erosiva, acidosis tubular renal distal (hipokalemia), neuropatía, vasculitis; anti-Ro en embarazo: riesgo de bloqueo AV congénito.
- Riesgo de linfoma no Hodgkin B tipo MALT (~40 veces): alarma ante parótida unilateral dura y persistente, púrpura, crioglobulinemia, C4 bajo, adenopatías.
- Manejo inicial: lágrimas artificiales sin preservantes, sustitutos salivales, pilocarpina si hay reserva glandular, higiene dental estricta y control odontológico; evitar anticolinérgicos.
- Seguimiento: derivar a reumatología para confirmar y vigilar complicaciones.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2018 · PREGUNTA 08

Mujer de 52 años consulta por sensación de cuerpo extraño ocular persistente y boca seca de 8 meses. Al examen se observa hiperemia conjuntival bilateral y caries cervicales múltiples. El test de Schirmer arroja 3 mm en 5 minutos en ojo derecho y 2 mm en ojo izquierdo. Los anticuerpos Anti-Ro (SSA) son positivos. ¿Cuál es la complicación neoplásica hematológica que presenta un riesgo incrementado de hasta 40 veces en esta patología?

A Leucemia mieloide aguda

B Linfoma No Hodgkin de células B (tipo MALT)

C Mieloma múltiple de cadenas pesadas

D Enfermedad de Hodgkin esclerosante nodular

E Carcinoma epidermoide de labio inferior

Respuesta B. Los pacientes con Síndrome de Sjögren primario tienen un riesgo relativo hasta 40 veces superior al de la población general de desarrollar Linfoma No Hodgkin de células B, especialmente del subtipo de tejido linfoide asociado a mucosas (Linfoma MALT) con asiento en glándulas salivales mayores (parótidas) o tracto digestivo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 48 años consulta por sensación constante de arenilla en ambos ojos y ardor ocular que le dificulta leer y usar pantallas, de 1 año de evolución. Además refiere boca seca que la obliga a levantarse por las noches a beber agua y necesidad de líquidos abundantes para deglutir alimentos secos como pan o galletas. Su odontólogo le ha tratado 5 caries en el cuello de las piezas dentarias en los últimos 6 meses. Al examen físico se palpa aumento de volumen indoloro y blando de ambas glándulas parótidas. El test de Schirmer muestra un lagrimeo de 2 mm en 5 minutos en ambos ojos. Los exámenes revelan ANA positivos 1:320 y anticuerpos Anti-Ro (SSA) fuertemente positivos. **¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y cuál es el pilar del tratamiento sintomático inicial?**

A Síndrome de Sjögren primario; indicar lágrimas artificiales sin preservantes, lubricantes salivales y medidas de higiene oral estricta

B Lupus eritematoso sistémico; iniciar pulsos de ciclofosfamida endovenosa urgente

C Sarcoidosis sistémica; iniciar prednisona oral 1 mg/kg/día por seis meses

D Amiloidosis primaria; programar biopsia de grasa subcutánea periumbilical

E Artritis reumatoide seronegativa; iniciar metotrexato subcutáneo inmediato

Respuesta A. El cuadro clínico reúne todos los criterios del Síndrome de Sjögren primario: queratoconjuntivitis seca sintomática y objetivada por Test de Schirmer patológico (< 5 mm en 5 minutos), xerostomía severa con caries rampantes de cuello, hipertrofia parotídea bilateral indolora y presencia de autoanticuerpos Anti-Ro (SSA) positivos. El tratamiento inicial de las manifestaciones sicca es el reemplazo tópico con lágrimas artificiales, lubricación salival constante, pilocarpina oral si hay reserva...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 126

Una paciente de 43 años presenta sequedad bucal, asociada a ardor y sensación de arenilla ocular y a artralgias. Al examen físico tiene sequedad de piel y de mucosas, se observa aumento de volumen de ambas parótidas y se palpan adenopatías submandibulares de consistencia aumentada. Se solicitan exámenes, que muestra FR: 40 UI/nl, ANA positivos 1/16, ENA negativo, antiDNA negativo. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio diagnóstico?

A Punción parotidea

B Biopsia ganglionar

C Anticuerpos anti-CCP

D Biopsia de glándula salival accesoria

E Anticuerpos anti-Sm

Respuesta D. La historia es compatible con un síndrome de Sjögren (tiene el síndrome de Sicca: xeroftalmia y xerostomía). El 90% tiene FR positivo. Además, es frecuente que tengan positivos los ANA, con un perfil ENA que muestra anticuerpos anti-Ro o anti-La positivos. Se confirma la biopsia de glándula salival menor o con los anticuerpos anti-Ro o anti-La, aunque actualmente el diagnóstico se realiza en base a una serie de criterios clínicos y de laboratorio, que no vale la pena aprenderse.

▶ VER CLASE 1.11.1.023 Síndrome de túnel carpiano

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.19 · Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Compresión del nervio mediano bajo el retináculo flexor: parestesias del pulgar, índice y medio, de predominio nocturno, que despiertan y ceden al sacudir la mano (signo de Flick).
- Factores: mujer, embarazo, diabetes, hipotiroidismo, AR, obesidad, trabajo con movimientos repetitivos de muñeca (posible enfermedad profesional).
- Examen: Phalen (flexión de muñecas 60 s) y Tinel positivos; atrofia tenar y debilidad de la abducción del pulgar indican severidad. Pedir TSH y glicemia.
- Confirmación con electromiografía y velocidad de conducción, obligatoria antes de la cirugía y en casos dudosos (diferencial con radiculopatía C6-C7 o polineuropatía).
- Manejo inicial (leve-moderado): férula nocturna con muñeca en posición neutra por 4-8 semanas, modificación de la actividad, tratar la causa; infiltración con corticoide; en el embarazo suele resolver tras el parto.
- Seguimiento: derivar a cirugía (liberación del túnel carpiano) si hay atrofia tenar, déficit motor o sensitivo persistente o refractariedad al tratamiento conservador.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 48 años, costurera, con 4 meses de parestesias en pulgar, índice y dedo medio derechos, que la despiertan en la noche y mejoran al sacudir la mano. Examen: signos de Phalen y Tinel positivos en la muñeca derecha, fuerza conservada y sin atrofia de la eminencia tenar. TSH y glicemia normales. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A Liberación quirúrgica del túnel carpiano de inmediato

B Resonancia magnética de columna cervical

C Prednisona 60 mg/día por 2 semanas

D Férula nocturna de muñeca en posición neutra y modificación de actividades

E Gabapentina en dosis altas como único tratamiento

Respuesta D. Túnel carpiano leve a moderado (síntomas sensitivos, sin déficit motor ni atrofia tenar): manejo conservador con férula nocturna en posición neutra, pausas y modificación de la actividad; puede agregarse infiltración con corticoide. La cirugía se indica si hay atrofia o debilidad tenar, denervación en la electromiografía o falla del tratamiento conservador.

▶ VER CLASE 1.11.1.024 Tendonitis y bursitis

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.11 · Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Tendinitis: dolor al palpar y estirar o contraer contra resistencia el tendón comprometido, por sobreuso. De Quervain (borde radial de la muñeca, Finkelstein positivo), pata de ganso (anteromedial de rodilla), rotuliana, banda iliotibial (lateral de rodilla en corredores), Aquiles, manguito rotador.
- Bursitis: aumento de volumen superficial, visible y fluctuante, con eritema: olecraniana (punta del codo), prepatelar, trocantérica (dolor lateral de cadera al dormir sobre ese lado, obesas).
- Diferenciar de artritis séptica: en la bursitis la movilidad articular pasiva es libre; en la artritis duele todo el rango de movimiento. Bursitis con fiebre o celulitis: puncionar para Gram y cultivo (bursitis séptica, S. aureus).
- Tratamiento: reposo relativo y modificación de la actividad, AINE, frío local, ortesis (férula en De Quervain) y kinesioterapia.
- Infiltración con corticoide en casos refractarios (no en el tendón de Aquiles por riesgo de rotura).
- Seguimiento completo en APS; evaluar origen laboral (Ley 16.744) y derivar si no mejora en 6-12 semanas.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un obrero de 50 años consulta por aumento de volumen en la punta del codo derecho, de una semana, con eritema local y dolor leve. Mueve el codo en todo su rango sin dolor y no tiene fiebre. No hay derrame articular profundo. **¿Cuál es el diagnóstico y el manejo inicial?**

A Artritis séptica de codo; punción articular y antibióticos

B Bursitis olecraniana; AINE y frío local

C Epicondilitis lateral; epicondilera

D Gota de codo; alopurinol

E Bursitis olecraniana; cirugía inmediata

Respuesta B. Un aumento de volumen visible en la punta del codo, con eritema, superficial y con movilidad conservada, es una bursitis olecraniana. Se trata con AINE y frío local; los corticoides quedan para los casos refractarios. La artritis séptica tiene derrame profundo y limitación dolorosa de todo el rango de movimiento.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 35 años, tenista amateur, consulta por dolor en la cara lateral del codo derecho de dos meses de evolución, que aumenta al extender la muñeca contra resistencia. No hay eritema ni aumento de volumen articular. **¿Cuál es el diagnóstico y el manejo inicial correcto?**

A Bursitis del olécranon: AINE más calor local

B Epitrocleitis o codo del golfista: reposo, AINE y epicondilera

C Artritis séptica de codo: punción articular urgente y antibióticos

D Epicondilitis lateral o codo del tenista: reposo, AINE, epicondilera y kinesioterapia

E Tendinitis del manguito rotador: ecografía de hombro y corticoides

Respuesta D. La epicondilitis lateral afecta la inserción de los extensores del antebrazo en el epicóndilo. Da dolor en la cara lateral del codo que aumenta con la extensión de la muñeca contra resistencia, y es frecuente en tenistas. Se trata con reposo relativo, AINE, kinesioterapia y epicondilera. No hay eritema ni aumento de volumen, lo que descarta bursitis y artritis séptica.

▶ VER CLASE 1.11.1.025 Vasculitis sistémicas

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Nefrología 4.4 · Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP) y Vasculitis ANCA
Reumatología 9.20 · Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis
Reumatología 9.21 · Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu
Reumatología 9.22 · Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

QUÉ HAY QUE SABER

- Clasificar por tamaño de vaso: grandes (arteritis de células gigantes en >50 años; Takayasu en mujeres jóvenes con asimetría de pulsos y soplos), medianos (poliarteritis nodosa, Kawasaki) y pequeños (ANCA: GPA, PAM, EGPA; IgA/Henoch-Schönlein); Behçet de vaso variable.
- Sospechar ante síntomas constitucionales con VHS/PCR altas más púrpura palpable, mononeuritis múltiple, glomerulonefritis (hematuria dismórfica, cilindros), hemorragia alveolar, sinusitis destructiva o nódulos pulmonares cavitados.
- Arteritis temporal (cefalea nueva, claudicación mandibular, amaurosis, VHS >50): iniciar prednisona 1 mg/kg de inmediato (pulsos si hay síntomas visuales) sin esperar la biopsia, que se hace dentro de 2 semanas.
- ANCA: c-ANCA/anti-PR3 en GPA (vía aérea alta, nariz en silla de montar), p-ANCA/anti-MPO en PAM (riñón-pulmón sin vía aérea alta) y EGPA (asma grave, eosinofilia).
- Henoch-Schönlein: púrpura palpable en nalgas y piernas con plaquetas normales, artralgias, dolor abdominal y nefritis IgA; manejo sintomático y control de orina y presión arterial por 6 meses.
- Síndrome riñón-pulmón o GNRP es emergencia: hospitalizar y derivar (pulsos de metilprednisolona + ciclofosfamida o rituximab, cotrimoxazol profiláctico).

PREGUNTAS · 11

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 106

Una paciente de 76 años presenta, desde hace un mes tos, disnea y expectoración, que en ocasiones es hemoptoica. A lo anterior se agrega hematuria, orinas espumosas, edema de extremidades inferiores y malestar general. En sus exámenes destaca creatinina: 4,6 mg/dl, BUN: 89 mg/dl, K: 5,9 mEq/L, Na: 130 mEq/L, proteinuria: 1.600 mg/24 horas, ANA negativos y complemento normal. **El diagnóstico más probable es:**

A Glomerulonefritis postestreptocócica

B Lupus eritematoso sistémico

C Tuberculosis miliar

D Vasculitis sistémica

E Púrpura trombocitopénico trombótico

Respuesta D. Síndrome riñón-pulmón (hemoptisis + GNRP) en una adulta mayor con ANA negativos y complemento normal: vasculitis sistémica, probablemente poliangeítis microscópica. El complemento normal descarta la postestreptocócica y el lupus.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 43

Un paciente de 75 años consulta por cefalea de 2 semanas de evolución, holocránea, intensa, que ha ido en aumento. En el último tiempo refiere además dolor al tocarse el cuero cabelludo y dolor en la rodilla derecha. Al examen físico se constatan signos de derrame articular de la rodilla derecha. Se realiza exámenes, entre los que figura un hemograma, con hemoglobina: 12,0 g/dl, blancos: 9.600 por mm3 y VHS: 76 mm/h. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Artritis seronegativa

B Arteritis de células gigantes

C Artritis reactiva

D Lupus

E Endocarditis aguda

Respuesta B. Cefalea nueva y progresiva en un mayor de 50 años (letra O de SNOOP10), con dolor al tocarse el cuero cabelludo y VHS muy elevada: arteritis de células gigantes. Por eso, ante toda cefalea nueva después de los 50 se piden VHS y PCR.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2019 · PREGUNTA 11

Hombre de 29 años consulta por aftas bucales dolorosas muy recurrentes en labios y encías desde hace 2 años y antecedentes de úlceras dolorosas en escroto que dejaron cicatriz. En la exploración oftalmológica se detecta uveítis anterior con nivel de hipopión en cámara anterior. Al realizar una prueba de punción cutánea con aguja estéril en el antebrazo se aprecia a las 36 horas una pápula eritematosa con una pústula estéril central de 3 mm. ¿Cómo se denomina esta prueba cutánea diagnóstica?

A Prueba de Mitsuda

B Fenómeno de Patergia

C Signo de Darier

D Prueba de Kveim-Siltzbach

E Signo de Nikolsky

Respuesta B. El desarrollo de una pápula eritematosa o pústula estéril entre las 24 y 48 horas posteriores a una microagresión traumática con aguja estéril en la piel del antebrazo se denomina Fenómeno de Patergia. Es un hallazgo semiológico característico de la Enfermedad de Behçet y traduce hiperreactividad del sistema inmune innato y neutrofílico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2022 · PREGUNTA 44

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las úlceras orales y genitales en la Enfermedad de Behçet es CORRECTA?

A Las úlceras orales son indoloras y las genitales no duelen

B Las úlceras genitales curan típicamente dejando cicatriz atrófica permanente, mientras que las orales curan sin cicatriz

C Las úlceras genitales se acompañan de adenopatías inguinales supurativas

D Las úlceras orales están presentes en menos del 20% de los pacientes diagnosticados

E El tratamiento de elección de las úlceras orales es aciclovir oral

Respuesta B. En la Enfermedad de Behçet las aftas bucales están presentes en el 100% de los casos y curan espontáneamente en 7-14 días sin dejar secuelas cicatriciales. En contraste, las aftas genitales (localizadas típicamente en escroto o vulva) son más profundas, sumamente dolorosas y curan dejando una cicatriz blanquecina o atrófica permanente que permite documentar retrospectivamente su presencia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2024 · PREGUNTA 12

Hombre de 28 años con diagnóstico de Enfermedad de Behçet presenta brotes frecuentes de aftosis oral y genital dolorosa recurrente, sin compromiso ocular, neurológico ni vascular en sus controles periódicos. ¿Cuál es el fármaco de primera línea de elección para prevenir y tratar estas manifestaciones mucocutáneas recurrentes?

A Ciclofosfamida endovenosa mensual

B Colchicina oral continua

C Infliximab endovenoso bimensual

D Acenocumarol oral ajustado por INR

E Metotrexato en dosis de 25 mg semanales

Respuesta B. La Colchicina oral (1 a 2 mg al día) constituye el tratamiento farmacológico de primera línea para las manifestaciones mucocutáneas (aftas orales recurrentes, aftas genitales y eritema nodoso) y articulares de la Enfermedad de Behçet. Su mecanismo de acción inhibe la polimerización de microtúbulos y la quimiotaxis excesiva de los neutrófilos. Los agentes biológicos o la ciclofosfamida se reservan para complicaciones graves que amenazan la visión o la vida.

PREGUNTA REAL · EUNACOM · AHORRADOR DE CORTICOIDES EN ARTERITIS TEMPORAL

En un paciente de 70 años con arteritis de células gigantes que ha presentado múltiples recaídas al intentar reducir la dosis de prednisona por debajo de 20 mg/día, desarrollando además fractura vertebral osteoporótica y diabetes inducida por corticoides. ¿Cuál es el fármaco biológico modificador de la enfermedad de primera línea con aprobación formal para actuar como ahorrador de corticoides en esta patología?

A Infliximab (anti-TNF alfa)

B Tocilizumab (antagonista del receptor de interleucina-6)

C Rituximab (anti-CD20 de células B)

D Anakinra (antagonista del receptor de interleucina-1)

E Secukinumab (inhibidor de interleucina-17A)

Respuesta B. Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra el receptor de la interleucina-6 (IL-6R). El ensayo pivotal GiACTA demostró que la adición de Tocilizumab permite alcanzar y sostener la remisión libre de corticoides en más del 50% de los pacientes con arteritis de células gigantes, reduciendo sustancialmente la dosis acumulada de glucocorticoides y sus severos efectos adversos osteoporóticos y metabólicos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM · SOSPECHA CLÍNICA DE ARTERITIS DE TAKAYASU

Mujer de 26 años consulta por astenia, mareos posturales y parestesias progresivas en el brazo derecho al escribir o trabajar en el teclado. Al examen físico se constata presión arterial de 135/85 mmHg en el brazo izquierdo y 95/60 mmHg en el brazo derecho (diferencia de 40 mmHg), con pulso radial derecho apenas perceptible. A la auscultación se detecta un soplo sistólico eyectivo intenso en la región supraclavicular derecha y en el trayecto carotídeo. La VSG se encuentra en 65 mm/h y la PCR en 32 mg/L. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica principal y el método de imagen vascular de elección para confirmar el diagnóstico?

A Enfermedad de Kawasaki · Ecocardiograma transtorácico con foco en arterias coronarias

B Poliarteritis Nodosa · Biopsia de nervio sural y piel

C Arteritis de Takayasu · Angio-Resonancia Magnética (o Angio-TC) de aorta y troncos supraaórticos

D Síndrome de Raynaud primario · Capilaroscopía periungueal

E Granulomatosis con Poliangeítis · Radiografía simple de tórax y senos paranasales

Respuesta C. El cuadro clínico de una mujer joven (< 40 años) con síntomas isquémicos en extremidades superiores, marcada asimetría de pulsos periféricos y de presión arterial (> 10-20 mmHg de diferencia entre ambos brazos), soplos vasculares carotídeos/supraclaviculares y reactantes de fase aguda elevados es patognomónico de la Arteritis de Takayasu ("enfermedad sin pulsos"). El estudio de elección es la Angio-RM o Angio-TC toracoabdominal, que evidencia engrosamiento parietal inflamatorio, estenosis o...

PREGUNTA REAL · EUNACOM · SEMIOLOGÍA EN ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES

¿Cuál de los siguientes signos o síntomas clínicos presenta la mayor especificidad semiológica para confirmar isquemia vascular craneal activa en un paciente con sospecha de Arteritis de la Temporal?

A Cefalea holocraneana pulsátil

B Claudicación mandibular al masticar

C Mialgias proximales en cinturas

D Fiebre vespertina de origen desconocido

E Sudoración nocturna profusa

Respuesta B. La claudicación mandibular (dolor y fatiga de los músculos maseteros al masticar que cede con el reposo) es el síntoma clínico más específico de la arteritis de la temporal, reflejando isquemia inducible de las arterias maxilares y linguales. Los otros síntomas son muy frecuentes pero poco específicos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM · PATRONES SEROLÓGICOS ANCA

¿Cuál de las siguientes asociaciones entre vasculitis de vaso pequeño y su patrón serológico de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) más característico y prevalente es CORRECTA?

A Granulomatosis con Poliangeítis (GPA) · c-ANCA (Anti-Proteinasa 3 / PR3)

B Poliangeítis Microscópica (PAM) · c-ANCA (Anti-Proteinasa 3 / PR3)

C Púrpura de Henoch-Schönlein · c-ANCA a títulos altos

D Arteritis de la Temporal · p-ANCA (Anti-Mieloperoxidasa / MPO)

E Enfermedad de Behçet · p-ANCA positivo universal

Respuesta A. La Granulomatosis con Poliangeítis (GPA) se asocia fuertemente (85-90%) al patrón c-ANCA (citoplasmático) con especificidad antigénica contra la Proteinasa 3 (PR3). Por su parte, la Poliangeítis Microscópica (PAM) y la Granulomatosis Eosinofílica (EGPA) se asocian al patrón p-ANCA (perinuclear) contra la Mieloperoxidasa (MPO). La vasculitis por IgA (Henoch-Schönlein) y las vasculitis de vaso grande no presentan ANCA.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años consulta por epistaxis recurrente, sinusitis purulenta de 4 meses rebelde a antibióticos y disnea progresiva con hemoptisis escasa. Al examen físico destaca perforación del tabique nasal cartilaginoso con hundimiento del dorso de la nariz (nariz en silla de montar). La tomografía de tórax revela múltiples nódulos bilaterales de paredes gruesas con cavitación central. Los exámenes muestran creatinina de 2.8 mg/dL, sedimento de orina con hematuria dismórfica y cilindros hemáticos, y anticuerpos c-ANCA (anti-PR3) fuertemente positivos a títulos altos. **¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y cuál es el esquema de inducción inmunosupresora de primera línea?**

A Granulomatosis con Poliangeítis (GPA); indicar pulsos de Metilprednisolona EV seguidos de Rituximab (o Ciclofosfamida) más profilaxis con Cotrimoxazol

B Poliangeítis microscópica; prescribir prednisona oral 20 mg al día en monoterapia ambulatoria

C Tuberculosis pulmonar cavitada multirresistente; iniciar esquema cuádruple con rifampicina e isoniacida

D Lupus eritematoso sistémico con nefritis clase cuatro; indicar hidroxicloroquina exclusiva

E Aspergiloma pulmonar invasor; iniciar voriconazol endovenoso continuo

Respuesta A. El cuadro clínico reúne la tríada patognomónica de la Granulomatosis con Poliangeítis (GPA): compromiso de vía aérea superior destructivo con sinusitis y nariz en silla de montar, compromiso pulmonar con nódulos cavitados bilaterales, glomerulonefritis necrotizante pauciinmune con falla renal y positividad para c-ANCA (anti-PR3). El tratamiento de inducción para la enfermedad con compromiso de órgano noble consiste en pulsos de metilprednisolona asociados a Rituximab (o ciclofosfamida),...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 157

Una paciente de 65 años consulta por un cuadro de 3 meses de evolución de aste- nia y debilidad de las cuatro extremidades, asociada mialgias. Al examen físico presen- ta dolor a la palpación de los músculos trapecios y supraespinosos y de la región trocan- térica. En sus exámenes destaca CK: 125 UI/L, y hemograma con VHS: 65 mmHg. El diag- nóstico más probable es:

A Fibromialgia

B Artritis reumatoide

C Polimiositis

D Polimialgia reumática

E Vasculitis

Respuesta D. Si bien parecía a simple vista una fibromialgia, la edad, la VHS alta y las Ck eleva- das hacen sospechar una plomialgia reumática.

Situaciones clínicas de urgencia

2 códigos

▶ VER CLASE 1.11.2.001 **Artritis séptica** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.2 · Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos

QUÉ HAY QUE SABER

- Monoartritis aguda febril de articulación grande (rodilla, cadera, hombro, codo) con dolor intenso a la movilidad activa y pasiva; la fiebre puede faltar en ancianos e inmunosuprimidos.
- Factores de riesgo: AR previa, diabetes, prótesis, diálisis, drogas EV, infiltración reciente. Gérmenes: S. aureus (50-60%), estreptococos, gramnegativos en ancianos; gonococo en joven sexualmente activo (tenosinovitis y pústulas).
- Artrocentesis antes del antibiótico: líquido purulento, >50.000 leucocitos con >90% PMN, glucosa <50% de la plasmática, Gram y cultivo; los cristales no la descartan. Tomar 2 hemocultivos.
- Tratamiento inicial: antibiótico EV empírico inmediato (cefazolina 2 g c/8 h o cloxacilina 2 g c/4 h; vancomicina si riesgo de SAMR; ceftriaxona si gonococo o gramnegativos).
- Drenaje articular obligatorio: punciones evacuadoras o artroscopía en rodilla; la cadera va a aseo quirúrgico urgente (riesgo de necrosis avascular).
- Seguimiento: derivar a traumatología/hospitalizar; antibiótico por 3-4 semanas.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 95

Un paciente de 68 años presenta monoartritis de rodilla izquierda, desde hace 48 horas. Al examen físico se observa aumento de volumen con signos de derrame articular, por lo que se punciona, dando salida a un líquido articular poco filante, con 50.000 glóbulos blancos por mm³, sin presencia de cristales. **Lo más probable es que se trate de una artritis:**

A Reactiva

B Seronegativa

C Reumatoide

D Séptica

E Psoriática

Respuesta D. Un líquido sinovial con 50.000 leucocitos/mm³ y filancia disminuida se ubica en el límite del rango séptico. Ante la ausencia de cristales y de clínica extraarticular sugerente de espondiloartropatía, la regla de oro obliga a tratar y asumir una artritis séptica hasta descartarla por completo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 39

Una paciente de 67 años consulta por un cuadro de dolor e impotencia funcional del codo derecho, asociado a fiebre, que inició hace 2 días. Al examen físico tiene temperatura de 39 grados Celsius, FC: 100x' y PA: 110/70 mmHg, asociado a aumento de volumen del codo derecho, con eritema y aumento de la temperatura local. Además, tanto la movilidad pasiva, como la activa, son muy dolorosas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Artritis reactiva
B Artritis séptica
C Artritis gotosa
D Condrocalcinosis
E Artritis reumatoide

Respuesta B. Monoartritis aguda febril con dolor extremo tanto a la movilidad activa como pasiva en una articulación como el codo es el cuadro clásico de artritis séptica. Las artropatías por cristales son mucho menos frecuentes en el codo y rara vez debutan con fiebre tan elevada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 103

Una paciente de 61 años, hipertensa y diabética, en tratamiento regular con hipoglicemiantes orales y antihipertensivos, desde hace 3 días presenta dolor y aumento de volumen en hombro derecho. Al examen físico presenta temperatura 38,2 °C, eritema, rubor y aumento de volumen del hombro derecho y limitación funcional, que impide el movimiento. El diagnóstico más probable es:

A Gota
B Condrocalcinosis
C Artritis reumatoidea
D Artritis séptica
E Artritis reactiva

Respuesta D. Paciente diabética con monoartritis aguda febril de hombro derecho. La diabetes es un factor de riesgo mayor para bacteriemia y artritis séptica. La localización en hombro y la presencia de fiebre alejan a la gota y condrocalcinosis, que afectan rodilla o pie.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 33 años consulta por dolor intenso y claudicación en la cadera izquierda de 24 horas de evolución, asociado a fiebre de 38,8 °C. La movilidad pasiva de la cadera es extremadamente dolorosa. La artrocentesis bajo ecografía da salida a líquido francamente purulento y la tinción de Gram revela cocáceas grampositivas en racimo. **¿Cuál es la conducta terapéutica de elección?**

A Iniciar cloxacilina oral y mantener en reposo en cama
B Iniciar ceftriaxona endovenosa e indicar descarga con muletas
C Iniciar vancomicina endovenosa y realizar punciones evacuadoras seriadas en sala
D Iniciar cefazolina endovenosa y realizar aseo quirúrgico urgente de la articulación
E Administrar corticoides intraarticulares y analgesia con opioides

Respuesta D. El hallazgo de cocos grampositivos en racimo orienta a Staphylococcus aureus sensible de la comunidad, tratable con cefazolina EV o cloxacilina EV. Por tratarse de la cadera, una articulación profunda e inextensible con alto riesgo de necrosis avascular de la cabeza femoral, el aseo quirúrgico urgente en pabellón es mandatorio.

▶ VER CLASE **1.11.2.002** **Gota aguda** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Reumatología 9.3 · Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)
Traumatología 12.12 · Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica

QUÉ HAY QUE SABER

- Gota aguda: podagra (1.ª MTF en 50-70%) de inicio nocturno explosivo, dolor que no tolera el roce, tumefacción violácea; gatillantes: alcohol, carnes, tiazidas, estrés, cirugía.
- Diagnóstico: clínico en la podagra típica; confirmación con cristales en aguja de birrefringencia fuertemente negativa. El ácido úrico es normal en 30-40% de las crisis: no descarta. Ante fiebre o duda, artrocentesis para descartar infección.
- Crisis: AINE en dosis plenas (naproxeno, indometacina) o colchicina en dosis bajas (1 mg + 0,5 mg a la hora); prednisona 30-35 mg/día por 5 días si hay IRC, úlcera o cardiopatía.
- Nunca iniciar alopurinol durante la crisis, ni suspenderlo si ya lo tomaba.
- Hipouricemiante si ≥2 crisis/año, tofos, erosiones o litiasis: alopurinol 100 mg/día (50 mg en IRC) titulado hasta uricemia <6 mg/dL (<5 si tofos), iniciado 2-4 semanas tras la crisis, con colchicina 0,5 mg/día por 3-6 meses como profilaxis.
- Seguimiento: derivar para manejo crónico; reducir alcohol y carnes rojas, bajar de peso y reemplazar tiazidas si es posible (losartán es uricosúrico).

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 30

Un paciente de 56 años, hipertenso y dislipidémico, en tratamiento con hidroclorotiazida y atorvastatina, consulta por dolor muy intenso en el pie derecho, especialmente en el primer ortejo, que inició hace algunas horas. Al examen físico tiene eritema del ortejo, el que es muy doloroso a la movilización. Se observa edema en dicho ortejo y en la zona bimaleolar. Se solicitan exámenes, que muestran hemograma, con leucocitos de 12.000 por mm³, PCR: 2 (VN: menor a 1 mg/L), creatinina: 0,8 mg/dl. ¿Cuál es el primer fármaco que debe administrarse para el manejo actual de este paciente?

A Diclofenaco sódico
B Cloxacilina
C Alopurinol
D Prednisona
E Clindamicina

Respuesta A. Cuadro típico de podagra aguda desencadenada por hidroclorotiazida. Con función renal normal (creatinina 0,8 mg/dl) y sin contraindicación gástrica, los AINEs potentes (como diclofenaco o naproxeno) son la primera línea tradicional para yugular la crisis. El alopurinol está estrictamente contraindicado en agudo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 55

Un paciente de 70 años, con cuadro de 2 horas de dolor y ardor en pie derecho. Al examen físico destaca eritema en primera articulación del pie derecho, sin otras alteraciones. Refiere que ha presentado este mismo cuadro en dos ocasiones en los últimos 6 meses. El tratamiento de elección en este paciente es:

A Probenecid
B Alopurinol
C Corticoides tópicos
D Paracetamol
E Colchicina

Respuesta E. Frente a una crisis aguda recurrente de gota (podagra), el objetivo inmediato es la supresión de la inflamación. Dentro de las opciones listadas, la colchicina oral es el tratamiento de elección para la crisis aguda. El alopurinol y probenecid están contraindicados durante el ataque agudo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 34

Un paciente de 48 años, obeso e hipertenso en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida consulta por dolor muy intenso y aumento de volumen en relación al primer ortejo derecho, de 24 horas de evolución. Al examen físico, tiene FC: 80x', PA: 144/96 mmHg, T°:37°C y se aprecia aumento de volumen y eritema de la primera articulación metatarsofalángica de ese pie, asociado a intenso dolor a la movilización. Refiere que ya había tenido un episodio similar hace un año. **¿Cuál es el fármaco de elección para el manejo de este paciente?**

A Diclofenaco
B Metotrexato
C Cloxacilina
D Alopurinol
E Prednisona

Respuesta E. Es una crisis de gota aguda, probablemente desencadenada por la hidroclorotiazida. La crisis se trata con AINE, prednisona o colchicina. Los AINE son la recomendación tradicional en Chile, pero las guías internacionales sugieren corticoides, que además evitan agravar la presión y el riñón de un paciente hipertenso. El alopurinol no se inicia en la crisis.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 64 años con antecedente de insuficiencia renal crónica etapa 3b (VFG 38 mL/min) y cardiopatía coronaria, consulta por 12 horas de dolor insoportable, tumefacción violácea y calor en la primera articulación metatarsofalángica derecha. Se realiza artrocentesis que confirma abundantes cristales en forma de aguja con birrefringencia intensamente negativa bajo luz polarizada. Su creatinina es de 2,2 mg/dL. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado para la crisis actual?**

A Indometacina 50 mg cada 8 horas por vía oral
B Alopurinol 300 mg al día por vía oral
C Prednisona 30 mg al día por vía oral por 5 días
D Colchicina 1 mg cada 2 horas hasta que aparezca diarrea
E Febuxostat 80 mg al día por vía oral

Respuesta C. En un paciente con insuficiencia renal crónica etapa 3b, los AINEs están absolutamente contraindicados por riesgo de falla renal aguda anúrica, y la colchicina tiene alto riesgo de toxicidad neuromuscular y renal. Los corticoides sistémicos (prednisona 30-35 mg/día por 5 días) son la terapia de primera línea de elección. El alopurinol y febuxostat están contraindicados durante la crisis aguda.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 52 años consulta por dolor muy intenso, de 12 horas, en el primer ortejo del pie izquierdo, con eritema y edema. Ha tenido tres episodios similares en el último año. No tiene fiebre ni toma tratamiento crónico. **¿Cuál es la conducta más adecuada ahora?**

A Iniciar alopurinol hoy

B Tratar la crisis con un antiinflamatorio y plantear alopurinol cuando se resuelva

C Iniciar antibióticos endovenosos

D Solicitar una resonancia de pie

E Iniciar colchicina como tratamiento permanente

Respuesta B. Es una podagra, que se diagnostica de forma clínica. La crisis se trata con antiinflamatorio (también sirven colchicina o corticoides). Como tuvo tres crisis en un año, tiene indicación de tratamiento crónico con alopurinol, pero nunca se inicia durante la crisis aguda. La colchicina no se deja como tratamiento permanente por sus efectos adversos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 47

Un paciente de 45 años ha presentado 3 episodios de gota en el último año, por lo que se inició tratamiento colchicina y luego se agregó alopurinol 100 mg/día. Actualmente está asintomático, sin signos de artritis y se controlar uricemia de 7 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Suspender el tratamiento

B Aumetar la dosis de alopurinol a 300 mg/día

C Agregar probenecid al tratamiento

D Suspender la colchicina

E Agregar prednisona en baja dosis

Respuesta D. La colchicina tiene muchos efectos adversos, por lo que se prefiere no dejarla como tratamiento profiláctico, sino solo en las crisis agudas (en agudo los AINEs son de elección). EL alopurinol debe mantenerse, ya que tuvo más de 2 crisis en 1 año y actualmente tiene buenos niveles de ácido úrico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 112

Un paciente de 43 años consulta por un cuadro de podagra. Tiene antecedente de dos crisis similares en los últimos 6 meses. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A Paracetamol

B Colchicina

C Probenecid

D Alopurinol

E Prednisona

Respuesta B. Es una pregunta muy complicada, ya que en el cuadro agudo actual (podagra) se debe indicar AINEs de elección y, si no está en las opciones, pues se indica la colchicina. Además, el hecho de que haya tenido más crisis en el último año (1 o más en un año) obliga a iniciar alopurinol, aunque no es posible iniciarlo ahora en agudo, mientras está con la podagra, sino que se debe esperar a que se resuelva, razón por la cual la respuesta es colchicina.

Conocimientos generales

3 códigos

▶ VER CLASE `1.11.3.001` **Condiciones de trabajo**

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.14 · Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastornos musculoesqueléticos de origen laboral: tendinitis de extremidad superior por movimientos repetitivos (De Quervain, epicondilitis, manguito rotador), túnel carpiano y lumbago por manejo manual de carga o posturas forzadas.
- Ley 16.744: las enfermedades profesionales y accidentes del trabajo (incluido el de trayecto directo casa-trabajo) se atienden en el organismo administrador (mutualidad o ISL), que cubre tratamiento, licencia y evaluación del puesto de trabajo.
- Ante sospecha de origen laboral: derivar al organismo administrador con la denuncia correspondiente (DIEP o DIAT), no emitir licencia común (tipo 1).
- Prevención: evaluación ergonómica del puesto (protocolos de vigilancia de trastornos musculoesqueléticos por movimientos repetitivos y manejo de carga), pausas activas, rotación de tareas y capacitación en técnicas de levantamiento.
- La licencia médica es un documento legal: emitirla sin evaluación clínica real es delito (fiscalización COMPIN/SUSESO).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 38 años, operaria de una planta de packing, consulta por dolor en el borde radial de la muñeca derecha de 2 meses, que relaciona con movimientos repetitivos en su trabajo. Prueba de Finkelstein positiva. **Además del manejo clínico, ¿qué corresponde según la legislación chilena?**

A Derivar a la mutualidad u organismo administrador de la Ley 16.744 como posible enfermedad profesional

B Licencia médica común por enfermedad (FONASA o ISAPRE)

C Indicarle que cambie de trabajo por su cuenta

D Ninguna gestión, porque es una patología común

E Notificar a la SEREMI como enfermedad de notificación obligatoria

Respuesta A. La tenosinovitis de De Quervain por movimientos repetitivos puede ser una enfermedad profesional. Según la Ley 16.744, las enfermedades profesionales y los accidentes laborales se atienden en el organismo administrador (mutualidad o ISL), que cubre tratamiento, licencia y prestaciones y evalúa el puesto de trabajo. Corresponde la denuncia individual de enfermedad profesional, no una licencia común.

▶ VER CLASE 1.11.3.002 Prevención de complicaciones de la terapia esteroidal

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.23 · Fibromialgia y Polimialgia Reumática: Diagnóstico Diferencial, Reactantes de Fase Aguda y Manejo en APS

QUÉ HAY QUE SABER

- Prednisona ≥2,5-5 mg/día por >3 meses produce osteoporosis (la causa secundaria más frecuente), diabetes, HTA, obesidad, cataratas y glaucoma, miopatía, infecciones, alteraciones psiquiátricas e insuficiencia suprarrenal al suspender.
- Hueso: calcio, vitamina D y bifosfonato en adultos mayores, osteopenia o uso prolongado; densitometría basal.
- Metabólico y cardiovascular: control periódico de glicemia, presión arterial, peso y lípidos; control oftalmológico.
- Infecciones: descartar TBC latente antes de dosis altas o prolongadas, vacunas inactivadas (influenza, neumococo) y evitar vacunas vivas en dosis inmunosupresoras; cotrimoxazol profiláctico en dosis altas prolongadas combinadas con otros inmunosupresores.
- Usar la menor dosis y el menor tiempo posible, con ahorradores de corticoides; IBP solo si se asocia AINE o hay antecedente de úlcera.
- Nunca suspender bruscamente tras >3 semanas: descenso gradual y dosis de estrés en cirugía o enfermedad grave. En esclerosis sistémica difusa evitar >15 mg/día (crisis renal).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 70 años con polimialgia reumática inicia prednisona 15 mg al día, con un plan de disminución lenta durante al menos 1 año. Su densitometría muestra un T-score de -2,1 en cadera. **¿Cuál es la medida más adecuada para prevenir complicaciones de la terapia esteroidal?**

A Ninguna medida preventiva, por tratarse de una dosis moderada

B Calcio, vitamina D y bisfosfonato, además de control de glicemia y presión arterial

C Suspender bruscamente la prednisona al mes

D Antibiótico profiláctico permanente

E Duplicar la dosis de prednisona ante cualquier estrés menor sin indicación

Respuesta B. El uso de prednisona de 2,5 mg o más por más de 3 meses causa osteoporosis, diabetes, hipertensión, cataratas, infecciones e insuficiencia suprarrenal al suspender. En adultos mayores con osteopenia se indica calcio, vitamina D y bisfosfonato, se controlan glicemia, presión y peso, y el descenso es gradual, nunca brusco. La profilaxis antibiótica no es rutinaria.

▶ VER CLASE 1.11.3.003 Riesgos deportivos

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.8 · Lesiones de Rodilla: Meniscos, Ligamentos Cruzados y Colaterales & Dolor Patelofemoral

QUÉ HAY QUE SABER

- Lesiones de rodilla frecuentes: rotura del ligamento cruzado anterior (giro con pie fijo, hemartros rápido, inestabilidad, cajón anterior y Lachman positivos), lesión meniscal (bloqueo, dolor en la interlínea, Apley) y esguince de colaterales (valgo/varo forzado).
- Meniscos y ligamentos no se ven en la radiografía: la resonancia es el examen de elección; LCA en jóvenes activos suele requerir reconstrucción artroscópica.
- Sobreuso: disfunción patelofemoral (dolor anterior con escaleras y estar sentado; fortalecer cuádriceps), tendinitis rotuliana y de la banda iliotibial, fracturas por estrés.
- Prevención: calentamiento, entrenamiento neuromuscular y de fortalecimiento progresivo, equipamiento y calzado adecuados, hidratación y evitar el ejercicio intenso con calor extremo.
- Evaluación preparticipativa: antecedentes de síncope o dolor torácico con ejercicio y muerte súbita familiar; ante sospecha de conmoción cerebral, retirar de la actividad y no volver el mismo día.
- Un esguince que no mejora o con dolor creciente obliga a radiografía y reevaluación.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Futbolista de 22 años que, al cambiar bruscamente de dirección con el pie apoyado, siente un chasquido en la rodilla derecha y no puede seguir jugando. En las horas siguientes la rodilla aumenta de volumen. Al examen hay derrame y la prueba de Lachman es positiva. **¿Cuál es la lesión más probable?**

A Tendinopatía rotuliana

B Rotura aislada del ligamento colateral medial

C Lesión del ligamento cruzado posterior

D Rotura del ligamento cruzado anterior

E Condromalacia patelar

Respuesta D. El mecanismo de pivote con pie fijo, el chasquido, la imposibilidad de continuar y la hemartrosis precoz son típicos de la rotura del ligamento cruzado anterior, confirmada por Lachman positivo; se estudia con resonancia. El cruzado posterior se lesiona por golpe directo en la tibia y da cajón posterior. Los programas de prevención neuromuscular reducen este riesgo deportivo.

Exámenes e imagenología

4 códigos

▶ VER CLASE 1.11.4.001 **Densitometría ósea** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.24 · Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica

QUÉ HAY QUE SABER

- Densitometría ósea (DEXA) de columna lumbar y cadera: mide densidad mineral ósea; es el examen para diagnosticar osteoporosis antes de una fractura y para seguimiento.
- T-score (comparación con adulto joven) en posmenopáusicas y hombres ≥50 años: ≥−1 normal; −1 a −2,5 osteopenia; ≤−2,5 osteoporosis; osteoporosis severa si además hay fractura por fragilidad.
- Z-score (comparación con la misma edad) en premenopáusicas, hombres <50 años y niños: ≤−2 es «baja masa ósea para la edad» y obliga a buscar causas secundarias.
- Indicaciones: mujeres ≥65 años, posmenopáusicas o hombres ≥70 con factores de riesgo, uso de corticoides >3 meses, enfermedades que causan osteoporosis; una fractura por fragilidad ya diagnostica osteoporosis sin requerir DEXA.
- Combinar con FRAX (tratar si fractura mayor ≥20% o cadera ≥3%) y repetir cada 1-2 años para evaluar respuesta al tratamiento.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM · DENSITOMETRÍA ÓSEA T-SCORE VS Z-SCORE

En la interpretación de una densitometría ósea mediante absorciometría de rayos X de doble energía (DEXA), ¿cuál es la diferencia conceptual y poblacional fundamental entre el T-score y el Z-score?

A El T-score compara la densidad mineral ósea con una población joven sana del mismo sexo en su pico de masa ósea, mientras que el Z-score compara con personas de la misma edad cronológica y sexo

B El T-score se utiliza exclusivamente en niños y adolescentes, mientras que el Z-score se utiliza en adultos mayores

C El T-score evalúa únicamente el hueso cortical periférico, mientras que el Z-score mide la trabecular vertebral

D Un Z-score bajo define osteoporosis clínica per se, mientras que el T-score solo predice artrosis

E El T-score y el Z-score son idénticos y se intercambian de forma aleatoria en el informe

Respuesta A. El T-score expresa el número de desviaciones estándar en relación con el pico de masa ósea medio de un adulto joven sano del mismo sexo (utilizado para clasificar osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y varones ≥ 50 años). El Z-score compara la DMO del paciente con los valores de referencia medios de personas de su misma edad y sexo; se usa en mujeres premenopáusicas, varones jóvenes y niños, y cuando es ≤ -2.0 DE obliga a buscar causas secundarias de osteoporosis.

▶ VER CLASE 1.11.4.002 **Estudio de líquido sinovial** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.1 · Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial
Reumatología 9.2 · Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos
Reumatología 9.3 · Artritis por Microcristales: Gota vs Condrocalcinosis (Pseudogota)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: toda monoartritis aguda o derrame articular no filiado; se obtiene antes de iniciar antibióticos.
- Estudio: aspecto, recuento celular con diferencial, glucosa, Gram, cultivo y cristales con microscopio de luz polarizada.
- Clasificación: normal <200 leucocitos; no inflamatorio 200-2.000 (artrosis, trauma); inflamatorio 2.000-50.000 (cristales, AR, espondiloartritis, reactiva); séptico >50.000 con >90% PMN y glucosa <50% de la plasmática; hemorrágico (trauma, hemofilia, fractura si tiene gotas de grasa).
- Cristales: urato en aguja con birrefringencia fuertemente negativa (gota); pirofosfato romboidal con birrefringencia débilmente positiva (condrocalcinosis).
- Trampas: los cristales no descartan infección (coexisten), la pseudogota puede superar 100.000 leucocitos, el Gram tiene sensibilidad ~50% y la artritis reactiva es inflamatoria pero estéril.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 8

Un adulto mayor presenta gonalgia bilateral, de dos años de evolución, que aumenta con la marcha. Hace algunas horas el dolor de la rodilla izquierda se vuelve mucho más intenso, apareciendo eritema, aumento de volumen y sensación febril. **¿Cuál es el examen más adecuado para este paciente?**

A Resonancia magnética de rodilla
B Radiografía de rodilla
C Hemograma y VHS
D Estudio de líquido articular
E TAC de rodilla

Respuesta D. Sobre una artrosis de base aparece una monoartritis aguda, inflamatoria y febril: hay que descartar artritis séptica y por cristales. El examen clave es la artrocentesis con estudio del líquido: recuento celular, Gram, cultivo y búsqueda de cristales. La radiografía y el hemograma ayudan, pero no confirman ni descartan infección.

▶ VER CLASE `1.11.4.003`

Exámenes inmunológicos del diagnóstico diferencial de mesenquimopatías (AAN, aDNA, aENA1, C3, C4, YGS, FR, Anti CCP, ANCA)

NIVEL **INTERPRETA Y EMPLEA**

DÓNDE SE ENSEÑA

Reumatología 9.6 · Artritis Reumatoide: Fisiopatología, Criterios ACR/EULAR 2010 y Manifestaciones Extraarticulares
Reumatología 9.8 · Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Inmunopatogenia, Criterios EULAR/ACR 2019 y Manejo Basal
Reumatología 9.15 · Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)

QUÉ HAY QUE SABER

- Los exámenes inmunológicos apoyan una sospecha clínica, no la reemplazan: FR o ANA positivos sin clínica (frecuentes en adultos mayores) no hacen diagnóstico ni se tratan.
- AR: FR sensible (~75%) pero poco específico; anti-CCP específico (>95%) y predictor de erosiones.
- LES: ANA ≥1:80 (sensibilidad >98%, criterio de entrada; negativo prácticamente descarta); anti-Sm el más específico; anti-dsDNA y C3/C4 bajos indican actividad y nefritis; anti-histona en lupus por fármacos.
- ENA: anti-Ro/La (Sjögren, lupus subagudo, bloqueo AV congénito), anti-Scl-70 (esclerosis difusa, EPID), anticentrómero (CREST, HAP), anti-Jo-1 (miositis antisintetasa), anti-U1-RNP (enfermedad mixta).
- Complemento bajo: LES activo, GN postinfecciosa, crioglobulinemia (VHC), endocarditis.
- ANCA: c-ANCA/anti-PR3 en granulomatosis con poliangeítis; p-ANCA/anti-MPO en poliangeítis microscópica y EGPA.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2018 · PREGUNTA 28

Mujer de 24 años consulta por eritema facial en mariposa que respeta surcos nasogenianos, fotosensibilidad, úlceras orales indoloras y poliartralgias en manos de 6 semanas. Para confirmar la sospecha clínica de Lupus Eritematoso Sistémico según los criterios EULAR/ACR 2019, ¿cuál es el examen inmunológico que constituye el criterio de entrada obligatorio e indispensable?

A Factor Reumatoide a títulos altos mayor a 3 veces el valor normal
B Anticuerpos Antinucleares (ANA) positivos en título mayor o igual a 1:80
C Niveles séricos de complemento C3 menores a 40 mg/dL
D Biopsia de piel sana con depósito de inmunoglobulinas en banda lúpica
E Anticuerpos Anti-Ro (SSA) positivos en dilución simple

Respuesta B. Según los criterios clasificatorios EULAR/ACR 2019 para Lupus Eritematoso Sistémico, el criterio de entrada obligatorio e ineludible es la presencia de Anticuerpos Antinucleares (ANA) positivos por inmunofluorescencia indirecta en células HEp-2 en título ≥ 1:80. Si este examen es negativo, el paciente no clasifica como LES independientemente de las otras manifestaciones clínicas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2021 · PREGUNTA 35

Mujer de 34 años consulta por fenómeno de Raynaud bilateral intenso, dedos de las manos tumefactos en salchicha (puffy fingers), debilidad muscular proximal en muslos y hombros con CPK elevada en 1.200 U/L y artralgias en muñecas. No presenta compromiso renal ni neurológico. Se solicitan anticuerpos antinucleares que resultan positivos en título 1:1.280 con patrón moteado. ¿Qué anticuerpo específico confirma el diagnóstico de Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo?

A Anticuerpos Anti-U1-RNP (ribonucleoproteína) a títulos elevados
B Anticuerpos Anti-centrómero
C Anticuerpos Anti-dsDNA
D Anticuerpos Anti-Scl-70
E Anticuerpos Anti-histona

Respuesta A. La presencia de características clínicas superpuestas de lupus, esclerodermia y polimiositis (Raynaud, dedos en salchicha, miositis proximal con CPK alta) asociada a la presencia de anticuerpos dirigidos contra la ribonucleoproteína U1 (Anti-U1-RNP) en títulos muy elevados (> 1:1.000) en ausencia de anti-dsDNA y anti-Sm define patognomónicamente la Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (Síndrome de Sharp).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 72 años, asintomático, sin dolor ni aumento de volumen articular, trae exámenes de un chequeo con factor reumatoide positivo de 40 UI/mL (valor normal menor de 14). Su examen articular es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar metotrexato precoz

B Diagnosticar artritis reumatoide seropositiva y derivar para terapia biológica

C Hidroxicloroquina preventiva

D No hace diagnóstico: el factor reumatoide puede ser positivo en adultos mayores sanos y en otras enfermedades, y sin artritis no se trata

E Repetir el factor reumatoide cada mes

Respuesta D. El factor reumatoide es poco específico: aparece en adultos mayores sanos y en hepatitis C, Sjögren, endocarditis o tuberculosis. Sin artritis clínica no tiene valor diagnóstico ni se trata. Los exámenes inmunológicos apoyan una sospecha clínica, no la reemplazan; el anti-CCP es el más específico para artritis reumatoide.

▶ VER CLASE 1.11.4.004 Radiografía de columna y articulaciones

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.4 · Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada

QUÉ HAY QUE SABER

- Artrosis: pinzamiento asimétrico, esclerosis subcondral, osteofitos y geodas, sin osteopenia ni erosiones (radiografía con carga en rodilla).
- Artritis reumatoide: osteopenia yuxtaarticular, pinzamiento simétrico y erosiones marginales; respeta IFD. Psoriásica: «lápiz en copa» y periostitis en IFD.
- Gota: erosiones en sacabocado con borde colgante (Martel), sin osteopenia. Condrocalcinosis: calcificación lineal de meniscos y fibrocartílago triangular.
- Espondilitis anquilosante: sacroilitis bilateral, cuadratura vertebral, sindesmofitos y «caña de bambú»; osteoporosis: aplastamientos vertebrales en cuña; espondilodiscitis: erosión de platillos contiguos con disco comprometido (los tumores lo respetan).
- Lumbago o cervicalgia mecánica sin banderas rojas no requiere radiografía en las primeras 4-6 semanas: no cambia el manejo y muestra hallazgos degenerativos irrelevantes.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2020 · PREGUNTA 04

¿Cuál de los siguientes autoanticuerpos presenta la mayor especificidad diagnóstica (superior al 99%) para el Lupus Eritematoso Sistémico?

A Anticuerpos Antinucleares (ANA)

B Anticuerpos Anti-Smith (Anti-Sm)

C Anticuerpos Anti-Ro (SSA)

D Anticuerpos Anti-Histona

E Anticuerpos Anticentrómero

Respuesta B. El anticuerpo Anti-Smith (Anti-Sm), dirigido contra una ribonucleoproteína del núcleo, es el marcador serológico más específico de Lupus Eritematoso Sistémico (> 99%), considerándose patognomónico. Aunque solo está presente en el 20-30% de los pacientes lúpicos (baja sensibilidad), su hallazgo confirma el diagnóstico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2022 · PREGUNTA 41

Una paciente de 30 años con diagnóstico confirmado de Lupus Eritematoso Sistémico en tratamiento con Hidroxicloroquina 200 mg al día consulta a control médico asintomática. En sus exámenes de control destaca elevación significativa de los títulos de anticuerpos Anti-dsDNA y una caída marcada en los niveles séricos de C3 (48 mg/dL, normal > 90) y C4 (6 mg/dL, normal > 15). ¿Qué significado clínico tienen estos hallazgos biológicos?

A Indican remisión completa y permiten suspender la hidroxicloroquina

B Son marcadores inequívocos de toxicidad farmacológica por antipalúdicos

C Traducen un brote de actividad autoinmune con consumo de complemento y riesgo de nefritis

D Corresponden a una infección bacteriana piógena sobreagregada

E Indican transformación maligna hacia linfoma de células B

Respuesta C. En el Lupus Eritematoso Sistémico, el aumento en los títulos de anticuerpos Anti-dsDNA asociado a hipocomplementemia (C3 y C4 disminuidos por consumo en la activación de la vía clásica por inmunocomplejos) es el marcador por excelencia de brote de actividad biológica lúpica, con un riesgo muy elevado de compromiso renal proliferativo agudo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 68 años con dolor mecánico de rodilla derecha de 3 años, rigidez matinal menor de 30 minutos y crépitos al examen. Se solicita radiografía de rodilla con carga. **¿Cuál conjunto de hallazgos radiológicos es característico de la artrosis?**

A Disminución asimétrica del espacio articular, osteofitos, esclerosis subcondral y quistes subcondrales

B Osteopenia yuxtaarticular, disminución simétrica del espacio y erosiones marginales

C Erosiones en sacabocado con borde sobresaliente

D Calcificación lineal del cartílago sin otros cambios

E Reacción perióstica en capas de cebolla

Respuesta A. La radiografía con carga es el examen de imagen inicial en la artrosis: muestra disminución asimétrica del espacio articular, osteofitos, esclerosis y quistes subcondrales. La osteopenia yuxtaarticular con erosiones marginales y estrechamiento simétrico es propia de la artritis reumatoide; las erosiones en sacabocado, de la gota, y la condrocalcinosis, de la pseudogota.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

1 códigos

▶ VER CLASE 1.11.5.001 **Punción articular de rodilla** NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Reumatología 9.1 · Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial
Reumatología 9.2 · Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: diagnóstica en monoartritis aguda o derrame no filiado (siempre antes del antibiótico); terapéutica para evacuar derrame a tensión, hemartrosis o pus, e infiltración.
- Contraindicación absoluta: celulitis o infección cutánea en el sitio de punción; precaución con coagulopatía o anticoagulación y prótesis.
- Técnica: paciente en decúbito supino con rodilla extendida y cuádriceps relajado; asepsia estricta; abordaje suprapatelar lateral o medial (bajo el borde superoexterno de la rótula), aguja 18-21 G dirigida bajo la rótula.
- Aspirar el máximo de líquido y enviar en tubos para citoquímico y recuento, Gram y cultivo, y cristales.
- Complicaciones: infección iatrogénica, hemartrosis, dolor; reevaluar si reaparece el derrame o la fiebre.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 42 años sin antecedentes mórbidos consulta en el servicio de urgencia por 14 horas de dolor intenso, calor y aumento de volumen en la rodilla derecha, que le impide apoyar la extremidad. Al examen físico: temperatura 38,3 °C, PA 125/75 mmHg, FC 92 lpm. Rodilla derecha con marcado derrame a tensión, eritema y dolor exquisito al mínimo intento de flexión activa o pasiva. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada e inaplazable?**

A Iniciar cloxacilina endovenosa y solicitar radiografía de rodilla

B Realizar artrocentesis diagnóstica para citoquímico, Gram, cultivo y cristales

C Administrar ketorolaco endovenoso y enviar a reposo con AINEs orales

D Iniciar alopurinol oral y solicitar niveles plasmáticos de ácido úrico

E Solicitar resonancia magnética de rodilla para evaluar ligamentos

Respuesta B. Frente a una monoartritis aguda febril con derrame a tensión, la conducta obligatoria, prioritaria e inaplazable es realizar artrocentesis diagnóstica. Iniciar antibióticos antes de la punción esteriliza el cultivo e impide confirmar el diagnóstico microbiológico.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 55 años, usuario de aspirina 100 mg al día, presenta una monoartritis aguda de la rodilla derecha con gran derrame. La piel de la cara medial de la rodilla tiene eritema por una celulitis. Se decide realizar una artrocentesis diagnóstica. **¿Cuál es la técnica correcta?**

A Decúbito supino con rodilla extendida y cuádriceps relajado, asepsia, abordaje lateral bajo el borde superolateral de la rótula, con aguja gruesa

B Punzar por la cara medial, donde el derrame es más fluctuante, aunque la piel tenga celulitis

C Abordaje posterior por el hueco poplíteo

D Iniciar antibióticos 48 horas antes de la punción

E Está contraindicada por el uso de aspirina en dosis bajas

Respuesta A. Con el paciente en decúbito supino, rodilla extendida y cuádriceps relajado, bajo técnica aséptica se punza por vía lateral, entre la rótula y el fémur, con aguja gruesa. Nunca a través de piel infectada ni por el hueco poplíteo, donde están los vasos. La aspirina no la contraindica, y el antibiótico va después de obtener el líquido.

12

CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA

155 CÓDIGOS

236 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	59
Situaciones clínicas de urgencia	31
Conocimientos generales	18
Exámenes e imagenología	15
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	32

Situaciones clínicas

59 códigos

▶ VER CLASE 4.01.1.001 Patología glándulas salivales

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.19 · Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo

QUÉ HAY QUE SABER

- Sialolitiasis (submandibular ~80%): dolor y aumento de volumen de la glándula al comer (cólico salival); cálculo palpable en piso de boca o visible en ecografía.
- Sialoadenitis bacteriana aguda (S. aureus): parótida dolorosa, eritematosa, con pus por el conducto de Stenon; típica en adulto mayor deshidratado o postoperado. Parotiditis viral (urleana): bilateral, sin pus.
- Tumores: la mayoría parotídeos y benignos (adenoma pleomorfo > Warthin). Sospechar malignidad si crecimiento rápido, dolor, fijación, adenopatías o parálisis facial.
- Manejo inicial: hidratación, sialogogos (limón), calor local, masaje y analgesia; en bacteriana, cloxacilina o amoxicilina-ácido clavulánico. Nunca biopsia incisional de masa parotídea.
- Seguimiento: derivar a cirugía de cabeza y cuello/ORL toda masa salival persistente (punción con aguja fina y eventual parotidectomía) y litiasis recurrente.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años consulta por aumento de volumen submandibular derecho, doloroso, que aparece al comer y cede en 1 a 2 horas, de 3 meses de evolución. Al examen se palpa la glándula submandibular aumentada de tamaño y una induración en el piso de la boca. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Parotiditis viral
B Adenoma pleomorfo
C Sialolitiasis submandibular
D Linfadenitis cervical bacteriana
E Síndrome de Sjögren

Respuesta C. El dolor y aumento de volumen glandular desencadenados por la comida (cólico salival) son típicos de sialolitiasis, que afecta principalmente a la glándula submandibular por su saliva más espesa y su conducto ascendente (Wharton). El adenoma pleomorfo es indoloro y no cambia con la ingesta.

▶ VER CLASE 4.01.1.002 Divertículos esofágicos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.3 · Disfagia y Trastornos Motores del Esófago

QUÉ HAY QUE SABER

- Divertículo de Zenker (faringoesofágico, por pulsión sobre el triángulo de Killian): adulto mayor con disfagia alta, regurgitación de alimentos no digeridos, halitosis, gorgoteo cervical y aspiración.
- Divertículos medioesofágicos (tracción, por adenopatías TBC/mediastínicas) suelen ser asintomáticos; epifrénicos (pulsión) se asocian a trastornos motores como acalasia.
- Estudio de elección: esofagograma baritado (EED). La endoscopía debe ser cuidadosa por riesgo de perforar el divertículo.
- Banderas rojas: neumonía aspirativa recurrente, baja de peso, hemorragia o sospecha de cáncer en el saco.
- Manejo inicial: dieta blanda, comer erguido, prevenir aspiración. Seguimiento: derivar a cirugía (miotomía cricofaríngea con diverticulectomía o tratamiento endoscópico) si es sintomático.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 78 años, autovalente, con disfagia alta, regurgitación de alimentos no digeridos, halitosis y 2 neumonías aspirativas en el último año. El esofagograma con bario confirma un divertículo de Zenker de 4 cm. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Observación y dieta blanda
B Omeprazol a permanencia
C Dilatación endoscópica con balón
D Miotomía del cricofaríngeo con resección o sección endoscópica del divertículo
E Gastrostomía definitiva

Respuesta D. El Zenker sintomático, sobre todo con aspiración, se trata con cirugía: la clave es la miotomía del cricofaríngeo, asociada a diverticulectomía o a diverticulotomía endoscópica. Ni los IBP ni la dilatación corrigen el mecanismo. Ojo: la endoscopía o la sonda a ciegas pueden perforar el divertículo.

▶ VER CLASE 4.01.1.003 Divertículo de Meckel

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.3 · Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

QUÉ HAY QUE SABER

- Regla de los 2: 2% de la población, a 2 pies (60 cm) de la válvula ileocecal, 2 pulgadas de largo, síntomas antes de los 2 años; divertículo verdadero (todas las capas) por persistencia del conducto onfalomesentérico.
- Presentación típica: hemorragia digestiva baja indolora en niño (mucosa gástrica ectópica que ulcera el íleon), rojo oscuro o «jalea de grosella».
- Otras formas: obstrucción intestinal (vólvulo, invaginación, banda), diverticulitis que simula apendicitis, hernia de Littré.
- Diagnóstico: cintigrafía con Tc-99m pertecnetato (capta mucosa gástrica ectópica); en sangrado activo, angiografía; muchas veces hallazgo intraoperatorio.
- Manejo inicial: estabilizar (accesos venosos, volumen, transfusión si corresponde), régimen cero. Seguimiento: derivar a cirugía pediátrica para resección del divertículo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 2 años, previamente sano, con rectorragia abundante de sangre rojo oscura, indolora. Está pálido, con FC 140 por minuto, abdomen blando e indoloro. La endoscopía digestiva alta es normal. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico más probable?**

A Colonoscopía

B Ecografía abdominal

C Cintigrafía con pertecnetato de tecnecio 99m

D Enema baritado

E Radiografía simple de abdomen

Respuesta C. Hemorragia digestiva baja abundante e indolora en un niño pequeño sugiere divertículo de Meckel con mucosa gástrica ectópica, que ulcera el íleon vecino. La cintigrafía con pertecnetato detecta esa mucosa. El tratamiento es la resección quirúrgica. Regla de los 2: 2 % de la población, a 2 pies de la válvula ileocecal, síntomas antes de los 2 años.

▶ VER CLASE 4.01.1.004 Acalasia

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.3 · Disfagia y Trastornos Motores del Esófago

QUÉ HAY QUE SABER

- Acalasia: falta de relajación del esfínter esofágico inferior y aperistalsis por pérdida de plexo mientérico; disfagia a sólidos y líquidos desde el inicio, regurgitación, baja de peso lenta.
- En Chile considerar enfermedad de Chagas (megaesófago) en paciente de zonas endémicas del norte o con familiares afectados.
- Esofagograma: dilatación esofágica con afinamiento distal en «pico de pájaro». Endoscopía obligatoria para descartar pseudoacalasia (cáncer de cardias).
- Confirmación: manometría esofágica (de alta resolución; clasificación de Chicago tipos I-III).
- Seguimiento: derivar a gastroenterología/cirugía para dilatación neumática, miotomía de Heller laparoscópica con funduplicatura o POEM; toxina botulínica en no candidatos. Mayor riesgo de cáncer escamoso.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 46 años con 8 meses de dificultad para tragar, más marcada con líquidos que con sólidos y de carácter fluctuante. Ha tenido 2 neumonías basales derechas en el último año y regurgita de noche alimentos sin sabor ácido. No ha bajado de peso. **¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico más probable?**

A Endoscopía digestiva alta con biopsia

B Manometría esofágica

C pH-metría esofágica de 24 horas

D TAC de tórax con contraste

E Prueba terapéutica con omeprazol por 8 semanas

Respuesta B. Disfagia ilógica (líquidos, fluctuante) + neumonías aspirativas + regurgitación no ácida = acalasia. La manometría confirma: aperistalsis y EEI hipertónico que no relaja. La endoscopía se hace igual para descartar pseudoacalasia, pero no confirma el trastorno motor.

▶ VER CLASE 4.01.1.005 Cáncer del esofágo

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.3 · Disfagia y Trastornos Motores del Esófago
Gastroenterología 1.5 · Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante disfagia progresiva (primero sólidos, luego líquidos), baja de peso, odinofagia, hematemesis o disfonía en mayor de 50 años: endoscopía alta con biopsia urgente.
- Escamoso (tercio medio, asociado a tabaco, alcohol, bebidas muy calientes, acalasia, cáusticos) vs adenocarcinoma (tercio distal, asociado a ERGE y esófago de Barrett, obesidad).
- Etapificación: TAC de tórax-abdomen-pelvis, endosonografía y PET-CT. Signos de irresecabilidad: disfonía (nervio laríngeo recurrente), fístula traqueoesofágica, metástasis.
- Manejo inicial: soporte nutricional (puede requerir sonda o gastrostomía), manejo del dolor, IBP. Cáncer esofágico incluido en GES (≥15 años) con confirmación y tratamiento garantizados.
- Seguimiento: derivar a cirugía digestiva/oncología (esofagectomía con quimiorradioterapia neoadyuvante, stent paliativo en irresecables). Barrett requiere vigilancia endoscópica.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 66 años, fumador de 40 paquetes-año y bebedor intenso, con 3 meses de disfagia progresiva, primero para sólidos y ahora también para papillas, con baja de 9 kg. Al examen está enflaquecido, sin adenopatías palpables. **¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico más probable?**

A Endoscopía digestiva alta con biopsias
B Esofagograma con bario
C Manometría esofágica
D TAC de tórax y abdomen
E PET-CT

Respuesta A. Disfagia lógica y progresiva con baja de peso en un fumador y bebedor sugiere cáncer escamoso de esófago. El diagnóstico se confirma con endoscopía y biopsia; la TAC y el PET-CT sirven después para etapificar, y el esofagograma solo orienta.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años, obeso, con 15 años de pirosis mal controlada. La endoscopía muestra una lesión ulcerada y estenosante en el tercio distal del esófago, cercana a la unión gastroesofágica. **Si la biopsia confirma un cáncer, ¿cuál es el tipo histológico más probable y su principal factor de riesgo?**

A Carcinoma escamoso; tabaco y alcohol
B Adenocarcinoma; esófago de Barrett por reflujo crónico
C Adenocarcinoma; infección por Helicobacter pylori
D Carcinoma escamoso; acalasia
E Linfoma; inmunosupresión

Respuesta B. El adenocarcinoma se ubica en el tercio distal y nace sobre un esófago de Barrett, consecuencia del reflujo crónico; la obesidad también es factor de riesgo. El escamoso predomina en los tercios superior y medio y se asocia a tabaco, alcohol, cáusticos y acalasia. H. pylori no causa cáncer esofágico.

▶ VER CLASE 4.01.1.006 Hernia hiatal

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.6 · Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino

QUÉ HAY QUE SABER

- Hernia hiatal por deslizamiento (tipo I, >90%): unión gastroesofágica sobre el diafragma; se asocia a ERGE (pirosis, regurgitación). Paraesofágica (tipo II-IV): fondo gástrico herniado con UGE en su lugar.
- Diagnóstico: endoscopía alta (también evalúa esofagitis y Barrett) o esofagograma; frecuentemente hallazgo en radiografía (nivel hidroaéreo retrocardíaco).
- Tratamiento inicial del deslizamiento: medidas generales (bajar de peso, elevar cabecera, evitar comidas copiosas y nocturnas) e IBP (omeprazol 20-40 mg/día).
- Banderas rojas en paraesofágica: dolor torácico intenso, vómitos sin poder vomitar, disfagia aguda o anemia: vólvulo gástrico o estrangulación, urgencia quirúrgica (tríada de Borchardt).
- Seguimiento: derivar a cirugía para funduplicatura de Nissen si ERGE refractaria o complicada y para toda hernia paraesofágica sintomática.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 72 años con plenitud y dolor torácico después de comer, más anemia ferropénica. La endoscopía y el estudio con bario muestran una hernia hiatal paraesofágica (tipo II), con el fondo gástrico en el tórax y la unión gastroesofágica en su posición normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Omeprazol a permanencia y control clínico
B Observación, ya que es frecuente en adultos mayores
C Reparación quirúrgica electiva
D Dilatación endoscópica
E Proquinéticos y medidas posturales

Respuesta C. La hernia paraesofágica sintomática tiene indicación quirúrgica por el riesgo de vólvulo, estrangulación y sangrado por lesiones de Cameron, que explican la anemia. La hernia por deslizamiento (tipo I), en cambio, se maneja como reflujo con IBP y solo se opera si fracasa el tratamiento médico.

▶ VER CLASE 4.01.1.007 Tumores gástricos benignos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.5 · Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Pólipos gástricos: hiperplásicos (asociados a H. pylori y gastritis), de glándulas fúndicas (uso prolongado de IBP), adenomatosos (potencial maligno, extirpar).
- GIST: tumor submucoso más frecuente del tubo digestivo (estómago ~60%), CD117/c-KIT positivo; puede presentarse con hemorragia digestiva alta o masa; riesgo según tamaño e índice mitótico.
- Otros submucosos: leiomioma, lipoma, páncreas ectópico. La mayoría asintomáticos y diagnosticados por endoscopía incidental.
- Estudio: endoscopía con biopsia, endosonografía para lesiones submucosas, TAC para extensión. Erradicar H. pylori si está presente.

- Seguimiento: derivar a gastroenterología/cirugía para polipectomía endoscópica o resección; GIST se reseca con márgenes y puede requerir imatinib.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 58 años, en estudio por dispepsia, se realiza una endoscopía digestiva alta que muestra un pólipo sésil de 2 cm en el antro. La biopsia informa adenoma tubular con displasia de bajo grado. Test de ureasa negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Control endoscópico en 5 años
B Erradicación de Helicobacter pylori y alta
C Gastrectomía subtotal
D Inhibidor de bomba de protones y control en 1 año
E Resección endoscópica completa del pólipo

Respuesta E. Los pólipos adenomatosos gástricos son lesiones premalignas: deben resecarse completos por vía endoscópica para obtener la histología definitiva, seguidos de vigilancia endoscópica. La gastrectomía es excesiva para un adenoma sin cáncer invasor, y el simple control deja una lesión con riesgo de transformación maligna.

▶ VER CLASE 4.01.1.008 Cáncer gástrico

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.5 · Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Chile tiene una de las tasas más altas de cáncer gástrico; principal causa de muerte por cáncer en hombres. Factores: H. pylori, gastritis atrófica, tabaco, dieta salada, familiar de primer grado.
- Síntomas tardíos: epigastralgia, baja de peso, anemia ferropénica, saciedad precoz, vómitos (obstrucción pilórica), hemorragia digestiva; signos de diseminación: ganglio de Virchow, Sister Mary Joseph, Blumer, Krukenberg.
- GES: endoscopía alta con biopsia en ≥40 años con epigastralgia de más de 15 días; también ante síntomas de alarma a cualquier edad.
- Manejo inicial: confirmar con endoscopía + biopsia, corregir anemia y estado nutricional; erradicar H. pylori en familiares y en lesiones premalignas.
- Seguimiento: derivar a cirugía digestiva (gastrectomía con linfadenectomía D2; resección endoscópica en cáncer incipiente) y oncología; etapificación con TAC.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 55

Paciente con antecedente de cáncer gástrico avanzado, con metástasis hepáticas múltiples y adenopatías perigástricas, consulta por vómitos postprandiales intensos, que han ido en aumento y actualmente dificultan mucho la alimentación. Al examen físico está muy enflaquecido, sin panículo adiposo y con edema de extremidades inferiores. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Instalar sonda nasogástrica
B Indicar nutrición parenteral total
C Realizar radioterapia de urgencia
D Realizar gastrectomía paliativa
E Realizar derivación gastrointestinal

Respuesta E. Es una obstrucción de la salida gástrica por un cáncer incurable. La paliación busca restablecer el tránsito con la menor morbilidad: una gastroyeyunoanastomosis (o una prótesis endoscópica) es menos agresiva que la gastrectomía paliativa. La sonda nasogástrica y la nutrición parenteral son medidas transitorias que no resuelven la obstrucción.

▶ VER CLASE 4.01.1.009 Tumores del intestino delgado

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 5.3 · Hemorragia Digestiva Alta y Baja

QUÉ HAY QUE SABER

- Raros (<5% de tumores digestivos). Benignos: adenomas, leiomiomas, lipomas, hamartomas (Peutz-Jeghers). Malignos: adenocarcinoma (duodeno), neuroendocrino (íleon), linfoma, GIST.
- Presentación: dolor abdominal vago, hemorragia digestiva oscura u oculta con anemia, obstrucción intermitente o invaginación en adulto (cabeza de invaginación tumoral).
- Síndrome carcinoide (rubor, diarrea, broncoespasmo, valvulopatía derecha) indica tumor neuroendocrino con metástasis hepáticas; medir 5-HIAA urinario.
- Estudio: TAC/enteroTAC, cápsula endoscópica o enteroscopía; endoscopía alta para lesiones duodenales.
- Manejo inicial: corregir anemia, manejar obstrucción (régimen cero, SNG, hidratación). Seguimiento: derivar a cirugía/gastroenterología para resección segmentaria.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 62 años presenta anemia ferropénica, test de hemorragia oculta positivo y episodios intermitentes de melena. Una endoscopía digestiva alta y una colonoscopía completa, con buena preparación, son normales. **¿Cuál es el siguiente examen más adecuado?**

A Repetir la colonoscopía en 3 años

B Enema baritado

C Cápsula endoscópica

D Ecografía abdominal

E Laparotomía exploradora

Respuesta C. Con endoscopía alta y colonoscopía normales, el sangrado probablemente proviene del intestino delgado (angiodisplasias o tumores como GIST, adenocarcinoma o neuroendocrinos). La cápsula endoscópica es el examen de elección para estudiarlo, y puede seguirse de enteroscopía o enteroTAC. Una laparotomía sin localización previa no corresponde.

▶ VER CLASE 4.01.1.011 Fístulas del intestino delgado

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.17 · Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Fístula enterocutánea: salida de contenido intestinal por la piel, la mayoría postoperatoria (filtración anastomótica); otras causas: Crohn, radiación, cáncer, cuerpo extraño.
- Débito alto (>500 ml/día) se asocia a deshidratación, hipokalemia, acidosis metabólica y desnutrición; las proximales (duodeno, yeyuno) son más graves.
- Factores que impiden el cierre espontáneo (FRIENDS): cuerpo extraño, radiación, inflamación/infección, epitelización, neoplasia, obstrucción distal, trayecto corto (<2 cm).
- Manejo inicial SNORA: control de sepsis (drenar colecciones), nutrición (parenteral si alto débito), proteger la piel (ostomía/bolsa), reponer volumen y electrolitos; octreótido puede reducir débito.
- Seguimiento: derivar a cirugía; la mayoría cierra con manejo conservador en 4-6 semanas, si no, cirugía diferida (≥3 meses).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 55 años, al quinto día de una resección intestinal por obstrucción, presenta salida de contenido bilioso por la herida operatoria, de aproximadamente 600 mL al día. Está afebril, hemodinámicamente estable y sin signos de peritonitis difusa. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Reoperación inmediata para cierre de la fístula

B Régimen liviano y alta con curaciones

C Reposo digestivo, reposición hidroelectrolítica, nutrición parenteral y protección de la piel

D Solo antibióticos de amplio espectro

E Sonda nasogástrica y alta precoz

Respuesta C. Una fístula enterocutánea de alto débito (más de 500 mL al día) sin sepsis se maneja inicialmente en forma conservadora: reposo digestivo, corrección de volumen y electrolitos, nutrición parenteral, control del débito y cuidado de la piel. Muchas cierran espontáneamente; reoperar precozmente un abdomen inflamado tiene alta morbilidad.

▶ VER CLASE 4.01.1.012 Megacolon

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.3 · Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

QUÉ HAY QUE SABER

- Enfermedad de Hirschsprung: ausencia de células ganglionares en recto-sigmoides; retraso en eliminación de meconio >48 h, distensión, vómitos, constipación severa desde el nacimiento; tacto rectal con salida explosiva de deposiciones.
- Diagnóstico: enema baritado (zona de transición) y confirmación con biopsia rectal por succión (aganglionosis, aumento de acetilcolinesterasa); manometría sin reflejo rectoanal inhibitorio.
- Megacolon adquirido en adulto: chagásico (zonas endémicas del norte de Chile), constipación crónica, fármacos. Megacolon tóxico: complicación de colitis ulcerosa o C. difficile, colon transverso >6 cm con toxicidad sistémica.
- Bandera roja: enterocolitis de Hirschsprung (fiebre, distensión, diarrea fétida) y vólvulo de sigmoides (más frecuente en megacolon chagásico).
- Manejo inicial: régimen cero, SNG, hidratación, descompresión rectal; en megacolon tóxico antibióticos y corticoides IV. Seguimiento: derivar a cirugía (pediátrica o coloproctología).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 112

Recién nacido de término, de 5 días de vida, aún no ha eliminado meconio. Además presenta irritabilidad, vómitos postprandiales frecuentes y distensión abdominal. Al examen tiene ano permeable. Se realiza un enema baritado, que muestra colon proximal dilatado y colon distal estrecho. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A TAC abdominal
B Colonoscopía
C Test del sudor
D Biopsia rectal por succión
E Cariograma

Respuesta D. Retraso en la eliminación de meconio, distensión y una zona de transición en el enema (colon distal estrecho y proximal dilatado) sugieren enfermedad de Hirschsprung. Se confirma con biopsia rectal por succión que demuestra ausencia de células ganglionares. El test del sudor se plantea ante un íleo meconial por fibrosis quística.

▶ VER CLASE 4.01.1.013 Enfermedad diverticular no complicada

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.3 · Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx

QUÉ HAY QUE SABER

- Diverticulosis: herniación de mucosa a través de la pared del colon, sobre todo sigmoides en Occidente; asociada a dieta pobre en fibra, edad y constipación. Mayoría asintomática (hallazgo en colonoscopía).
- Enfermedad diverticular sintomática no complicada: dolor en fosa ilíaca izquierda recurrente, distensión y cambios del hábito, sin fiebre ni signos peritoneales.
- Tratamiento: dieta rica en fibra (25-35 g/día), aumento de ingesta de agua, actividad física; no es necesario evitar semillas. Analgésicos y antiespasmódicos según síntomas.
- Diverticulitis no complicada leve (dolor FII, fiebre baja, sin peritonitis): manejo ambulatorio con dieta líquida y antibióticos opcionales (amoxicilina-clavulánico o ciprofloxacino + metronidazol) en inmunocompetente.
- Seguimiento completo: control clínico en APS, colonoscopía tras un episodio de diverticulitis (6-8 semanas) para descartar cáncer; derivar si complicaciones o episodios recurrentes con mala calidad de vida.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 60 años, asintomático, se realiza una colonoscopía de tamizaje que muestra múltiples divertículos en el colon sigmoides, sin signos inflamatorios ni otras lesiones. **¿Cuál es la indicación más adecuada?**

A Sigmoidectomía electiva
B Colonoscopía de control anual
C Ciprofloxacino y metronidazol por 7 días
D Evitar estrictamente semillas y frutos secos
E Dieta rica en fibra, sin controles específicos por los divertículos

Respuesta E. La diverticulosis asintomática no requiere tratamiento ni seguimiento específico; se recomienda dieta rica en fibra, actividad física y evitar el sobrepeso. No hay evidencia para restringir semillas o frutos secos, y la cirugía electiva no está indicada en la enfermedad no complicada.

▶ VER CLASE 4.01.1.014 Pólipos de colon y recto

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.5 · Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje

QUÉ HAY QUE SABER

- Pólipos adenomatosos (tubular < tubulovelloso < velloso en riesgo) son precursores del cáncer colorrectal; riesgo mayor si >1 cm, componente velloso o displasia de alto grado.
- Hiperplásicos pequeños de recto-sigmoides: bajo riesgo. Serrados sésiles: vía serrada, potencial maligno.
- Generalmente asintomáticos; pueden dar rectorragia o sangre oculta en deposiciones positiva. Síndromes hereditarios: poliposis adenomatosa familiar (cientos de pólipos, colectomía profiláctica), Lynch, Peutz-Jeghers.
- Pesquisa: test de sangre oculta inmunológico (FIT) desde los 50 años o colonoscopía; antecedente familiar de primer grado: colonoscopía desde los 40 años o 10 años antes del caso índice.
- Seguimiento: derivar a colonoscopía con polipectomía y vigilancia según histología (3-5 años en adenomas avanzados o múltiples).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En una colonoscopía realizada a un hombre de 28 años con antecedentes familiares de cáncer de colon se describen más de 150 pólipos distribuidos por todo el colon y el recto. Varias biopsias muestran adenomas tubulares con displasia de bajo grado. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Polipectomía endoscópica de los pólipos mayores y control anual

B Colectomía total (proctocolectomía) profiláctica

C Quimioprevención con AINE y seguimiento

D Control con CEA seriado cada 6 meses

E Colonoscopía de control en 3 años

Respuesta B. Cientos de pólipos adenomatosos en un joven con historia familiar: poliposis adenomatosa familiar, que evoluciona a cáncer en prácticamente el 100 % si no se interviene. La conducta es la colectomía total profiláctica; la polipectomía es inviable por el número de lesiones y no elimina el riesgo.

▶ VER CLASE 4.01.1.015 Cáncer colorectal

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Gastroenterología 2.5 · Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante rectorragia, cambio del hábito intestinal, anemia ferropénica (sobre todo en hombre o mujer posmenopáusica), baja de peso o masa abdominal en ≥50 años.
- Colon derecho: anemia y masa; colon izquierdo: obstrucción y cambio de calibre de deposiciones; recto: pujo, tenesmo, rectorragia.
- Confirmación: colonoscopía completa con biopsia; etapificación con TAC tórax-abdomen-pelvis, RM pélvica en recto y CEA basal.
- GES: cáncer colorrectal en ≥15 años (confirmación, tratamiento y seguimiento). Factores: adenomas, EII, Lynch, PAF, antecedente familiar, obesidad, carnes procesadas.
- Manejo inicial: corregir anemia, estudio; obstrucción o perforación son urgencia quirúrgica. Seguimiento: derivar a cirugía coloproctológica y oncología (colectomía, quimioterapia; neoadyuvancia en recto).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 74 años con 4 meses de constipación progresiva que antes no tenía, deposiciones más delgadas y episodios de rectorragia escasa. Hemograma: anemia microcítica hipocroma con ferritina baja. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Test de sangre oculta inmunoquímico

B Solicitar CEA para confirmar el diagnóstico

C Colonoscopía total con biopsia

D Fibra, laxantes y sulfato ferroso, control en 3 meses

E TAC de abdomen como examen diagnóstico inicial

Respuesta C. Constipación reciente, deposiciones acintadas, rectorragia y anemia ferropénica en una adulta mayor: cáncer colorrectal hasta demostrar lo contrario. Se confirma con colonoscopía total y biopsia; el test de sangre oculta es tamizaje de asintomáticos y el CEA solo sirve para el seguimiento. Luego se etapifica con TAC.

▶ VER CLASE 4.01.1.016 Hemorroides - fisura anal

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.7 · Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas
Gastroenterología 2.6 · Patología Perianal: Fisura, Hemorroides, Absceso y Fístula

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemorroides internas (sobre línea pectínea, indoloras): rectorragia roja rutilante que cubre deposiciones y prolapso; grados I-IV según prolapso y reducción. Externas: dolor intenso si se trombosan.
- Fisura anal: dolor intenso al defecar que persiste minutos-horas y rectorragia escasa; en línea media posterior. Aguda <6 semanas; crónica con papila hipertrófica, colgajo centinela y fibras del esfínter visibles.
- Diagnóstico específico: inspección anal, tacto rectal (si tolera) y anoscopía; fisura fuera de línea media obliga a descartar Crohn, TBC, VIH, sífilis o cáncer.
- Tratamiento médico: fibra 25-30 g/día, agua, baños de asiento tibios, evitar pujo; fisura: nifedipino 0,2-0,3% o nitroglicerina tópica 6-8 semanas y lidocaína tópica. Hemorroide externa trombosada <72 h: trombectomía con anestesia local.
- Seguimiento: control en APS; derivar a coloproctología hemorroides grado III-IV o refractarias (ligadura elástica, hemorroidectomía) y fisura crónica refractaria (toxina botulínica, esfinterotomía lateral interna). En >50 años con rectorragia, colonoscopía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 27

Paciente de 52 años con hemorroides externas trombosadas desde hace 6 horas, violáceas, protruidas, irreducibles y muy dolorosas. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Hemorroidectomía de urgencia
B Trombectomía hemorroidal bajo anestesia local
C Ligadura con banda elástica
D Manejo médico conservador con analgesia y baños de asiento
E Escleroterapia

Respuesta B. Hemorroides externas trombosadas dentro de las primeras 72 horas: la trombectomía bajo anestesia local alivia el dolor de inmediato. Pasado ese plazo, el trombo se reabsorbe solo y el manejo pasa a ser conservador.

▶ VER CLASE 4.01.1.017 Abscesos y fístulas ano rectales

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.7 · Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas
Gastroenterología 2.6 · Patología Perianal: Fisura, Hemorroides, Absceso y Fístula

QUÉ HAY QUE SABER

- Absceso anorrectal: dolor perianal continuo, pulsátil, que impide sentarse, con aumento de volumen eritematoso y fluctuante y fiebre; origen criptoglandular. Tipos: perianal, isquiorrectal, interesfintérico, supraelevador.
- Abscesos profundos (supraelevador, interesfintérico) dan dolor rectal y fiebre sin signos externos: tacto rectal doloroso y TAC/RM para confirmar.
- Tratamiento inicial: drenaje quirúrgico precoz (no esperar fluctuación); antibióticos solo si celulitis extensa, inmunosupresión, diabetes, valvulopatía o sepsis.
- Fístula perianal: secuela del absceso en ~30-50%; orificio externo con secreción crónica. Regla de Goodsall orienta al orificio interno. Descartar Crohn si múltiples o recurrentes.
- Seguimiento: derivar a coloproctología (fistulotomía, sedal, colgajo); gangrena de Fournier es urgencia quirúrgica con desbridamiento amplio y antibióticos de amplio espectro.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 38 años consulta por 2 días de dolor perianal continuo, pulsátil, que le impide sentarse, con sensación febril. Al examen, en el cuadrante posterolateral izquierdo se aprecia una masa de 3 cm, eritematosa, indurada, caliente y muy dolorosa a la palpación, sin fluctuación evidente. Temperatura 37,9 grados. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar ciprofloxacino más metronidazol oral y control en 5 días
B Realizar drenaje quirúrgico bajo anestesia, sin esperar más
C Indicar antiinflamatorios y baños de asiento
D Solicitar ecografía transrectal antes de decidir
E Puncionar con aguja fina en el policlínico

Respuesta B. Dolor perianal pulsátil, continuo y progresivo con masa indurada y eritematosa es un absceso perianal, incluso sin fluctuación clara todavía. La conducta es el drenaje quirúrgico inmediato; esperar antibióticos o una imagen retrasa el control del foco y favorece la extensión de la infección.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 38 años con dolor anal que ha ido aumentando durante 4 días, ahora intenso e invalidante, con fiebre de 38 °C. Al examen: tumoración perianal eritematosa, caliente y fluctuante a las 5 del reloj, sin nódulo violáceo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Baños de asiento y laxantes osmóticos
B Antibióticos orales y control en 48 horas
C Trombectomía ambulatoria
D Drenaje quirúrgico en pabellón
E Esfinterotomía lateral interna

Respuesta D. Dolor anal progresivo, masa eritematosa fluctuante y fiebre: absceso perianal. Se trata con drenaje quirúrgico en pabellón; los antibióticos solos no resuelven la colección. La fluctuación y la ausencia de nódulo violáceo lo separan del hemorroide externo trombosado.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años consulta porque desde hace 3 meses tiene un pequeño orificio en la piel de la región glútea, cercano al ano, que supura material purulento de forma intermitente. Tuvo un absceso perianal drenado hace 4 meses. **¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?**

A Fisura anal crónica; baños de asiento
B Fístula anal; tratamiento quirúrgico
C Hidradenitis supurativa; antibióticos prolongados
D Hemorroide interno grado IV; ligadura elástica
E Quiste pilonidal; observación

Respuesta B. Orificio cutáneo perianal que supura de forma crónica tras un absceso drenado: fístula anal, trayecto entre el canal anal y la piel. Tratamiento quirúrgico (fistulotomía o sedal). Error clásico: confundirla con la fisura, herida dolorosa de manejo médico.

▶ VER CLASE 4.01.1.018 Enfermedades del seno pilonidal

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.8 · Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

QUÉ HAY QUE SABER

- Enfermedad pilonidal: inflamación crónica por pelos incrustados en el surco interglúteo sacrococcígeo; típico en hombre joven, hirsuto, sedentario u obeso.
- Formas: asintomática (fositas en línea media), absceso pilonidal agudo (dolor, aumento de volumen fluctuante, fiebre) y sinus crónico con secreción intermitente.
- Absceso agudo: drenaje con incisión lateral a la línea media con anestesia local, aseo y curaciones; antibióticos solo si celulitis o inmunosupresión.
- Enfermedad crónica o recurrente: resección quirúrgica electiva (cierre primario fuera de la línea media tipo Karydakis/Limberg o cierre por segunda intención).
- Seguimiento: curaciones en APS, depilación de la zona (láser o rasurado) e higiene para prevenir recidiva; derivar a cirugía para resección definitiva.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 43

Paciente de 20 años presenta aumento de volumen eritematoso y doloroso en la zona interglútea, a dos centímetros de la línea media, sobre el cóccix. Al examen se observa aumento de volumen de 5 centímetros, doloroso, con dos orificios negros en la piel cerca de la lesión. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Linfoma
B Sarcoma
C Quiste pilonidal
D Absceso anorrectal
E Lipoma

Respuesta C. La ubicación sacrococcígea, sobre la línea media, con orificios puntiformes con pelos, es el cuadro característico del quiste o seno pilonidal, aquí ya en fase inflamatoria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 77

Paciente con absceso interglúteo de 2 centímetros, en buenas condiciones generales. **¿Cuál es la conducta?**

A Antibióticos exclusivos
B Drenar
C Marsupialización
D Solicitar cultivo antes de cualquier procedimiento
E Observación

Respuesta B. Todo absceso pilonidal se drena. Los antibióticos se pueden sumar, pero no reemplazan el drenaje; si el cuadro recurre, ahí sí se plantea la extirpación completa del quiste.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 24 años, con vello abundante y sobrepeso, consulta por 2 días de dolor y aumento de volumen en la región sacrococcígea, que empeora al sentarse. Al examen, en la línea interglútea se aprecia una masa de 3 cm, eritematosa, caliente y fluctuante, con un mechón de pelos saliendo por un orificio central. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Resección amplia en bloque del trayecto pilonidal
B Antibióticos orales por 10 días y control
C Drenaje quirúrgico simple con incisión lateralizada
D Solicitar resonancia magnética de pelvis antes de decidir
E Observación, ya que suele resolver solo

Respuesta C. Masa fluctuante, eritematosa y dolorosa en la región interglútea, con pelos visibles: absceso pilonidal agudo. La conducta es el drenaje quirúrgico simple, con incisión lateralizada y curetaje de pelos; la resección amplia se difiere para cuando ceda la infección.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 19

Un paciente de 47 años, obeso, consulta por dolor y aumento de volumen en la zona interglútea. Al examen físico se aprecia aumento de volumen en la zona sacra, de con- sistencia balnda, eritematoso y doloroso a la palpación. La conducta más adecuada es:

A Realizar drenaje quirúrgico con anestesia local
B Antibióticos orales
C Solicitar una ecografía de partes blandas
D Solicitar resonancia nuclear magnética de pelvis
E Solicitar TAC de abdomen y pelvis

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar drenaje quirúrgico con anestesia local (opción A). Es un quiste pilonidal infectado. Se debe drenar. Si no se infecta, solo se observa. La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

▶ VER CLASE 4.01.1.019 Cáncer anal

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.7 · Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

QUÉ HAY QUE SABER

- Carcinoma escamoso del canal anal asociado a VPH (16/18), VIH, HSH, inmunosupresión, tabaco y antecedente de neoplasia cervical o condilomas.
- Síntomas: sangrado, dolor anal, masa o úlcera indurada que no cicatriza, prurito, tenesmo; adenopatías inguinales. Se confunde con hemorroides o fisura.
- Toda lesión anal atípica, indurada o que no responde a tratamiento debe biopsiarse; tacto rectal y anoscopía obligatorios.
- Etapificación: RM pélvica, TAC de tórax-abdomen y examen de ganglios inguinales.
- Seguimiento: derivar a coloproctología/oncología; tratamiento de elección es quimiorradioterapia (esquema de Nigro: 5-FU + mitomicina), cirugía de rescate si persiste.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 89

Paciente de 45 años, con diagnóstico de VIH, presenta sangrado rectal ocasional. Al examen físico se observa una lesión solevantada en el margen anal, de 4 cm, que se introduce en el recto sobrepasando la línea pectínea, con ulceración central y escaso sangrado. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hemorroide externo trombosado
B Condiloma acuminado
C Sífilis
D Cáncer epidermoide
E Enfermedad de Crohn

Respuesta D. Una lesión indurada, solevantada y ulcerada que cruza la línea pectínea en un paciente con VIH (mayor persistencia del VPH) sugiere carcinoma epidermoide del ano, que debe confirmarse con biopsia. El condiloma es verrucoso y no ulcerado; el chancro sifilítico es más pequeño y de evolución breve.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 136

Un paciente de 50 años, con antecedente de infección de VIH, consulta por una le- sión perianal, de larga data, sin tendencia a la cicatrización. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, de consistencia aumentada, de 4 cm de diámetro, bordes cartográ- ficos y que se introduce por el ano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Sífilis
B Enfermedad de Cröhn
C Carcinoma epidermoide
D Melanoma
E Tuberculosis

Respuesta C. Diagnóstico: Carcinoma epidermoide (opción C). Es un cáncer de recto clásico.

▶ VER CLASE 4.01.1.020 Fisura anorectal

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.7 · Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas
Gastroenterología 2.6 · Patología Perianal: Fisura, Hemorroides, Absceso y Fístula

QUÉ HAY QUE SABER

- Fisura anal: desgarro del anodermo distal a la línea pectínea, 90% en línea media posterior; causada por paso de deposiciones duras y aumento de tono del esfínter interno.
- Clínica: dolor intenso y lacerante durante y después de defecar, sangre roja escasa en el papel; diagnóstico por inspección separando glúteos (tacto suele ser imposible por dolor).
- Crónica (>6 semanas): úlcera con bordes indurados, fibras del esfínter interno, colgajo centinela y papila hipertrófica. Fisuras laterales o múltiples: pensar en Crohn, TBC, VIH, sífilis o cáncer.

- Tratamiento: fibra y agua abundante, ablandadores, baños de asiento tibios, lidocaína tópica; relajantes del esfínter: nifedipino 0,2% o diltiazem 2% tópico (preferidos) o nitroglicerina 0,2-0,4% (cefalea) por 6-8 semanas; cura ~90% de agudas.
- Seguimiento: control en APS; derivar a coloproctología fisura crónica refractaria para toxina botulínica o esfinterotomía lateral interna (riesgo de incontinencia leve).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 54

Paciente de 54 años consulta por dolor anal que se presenta al defecar, persistiendo por algunos minutos luego de la defecación. En algunas ocasiones ha presentado sangre en las deposiciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hemorroide externo trombosado
B Cáncer de recto
C Fisura anal
D Fístula anal
E Absceso perianal

Respuesta C. Dolor que aparece al defecar y persiste después, con algo de sangrado: cuadro clásico de fisura anal. Ni la trombosis ni el absceso duelen así de específicamente ligados a la defecación, y no hay signos de cáncer.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 54

Hombre de 54 años consulta por dolor anal que se presenta al defecar, persistiendo por algunos minutos luego de la defecación. En algunas ocasiones ha presentado sangre en las deposiciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hemorroide externo trombosado
B Cáncer de recto
C Fisura anal
D Fístula anal
E Absceso perianal

Respuesta C. Dolor que aparece con la defecación y persiste minutos después, con sangrado escaso: es una fisura anal, por el espasmo del esfínter interno que sigue a cada episodio.

▶ VER CLASE 4.01.1.021 Hernias, eventraciones y evisceraciones

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.6 · Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones
Cirugía 11.17 · Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Hernia inguinal indirecta (por anillo inguinal profundo, lateral a vasos epigástricos; la más frecuente en ambos sexos) vs directa (triángulo de Hesselbach, adulto mayor). Femoral: bajo ligamento inguinal, más en mujeres, alto riesgo de estrangulación.
- Diagnóstico clínico: aumento de volumen reductible que protruye con Valsalva; ecografía si duda. Eventración: hernia a través de cicatriz quirúrgica (factores: infección de herida, obesidad, tos, desnutrición).
- Hernia atascada (irreductible) o estrangulada (dolor intenso, eritema, signos de obstrucción o toxicidad): urgencia quirúrgica; no intentar reducir si hay signos de estrangulación.
- Evisceración: salida de vísceras por dehiscencia de laparotomía (día 5-8, precedida por salida de líquido serohemático): cubrir con compresas estériles húmedas con suero, no reducir, pabellón urgente.
- Tratamiento definitivo es quirúrgico (hernioplastía con malla, Lichtenstein o laparoscópica); GES hernia de pared abdominal en 15 años y más. Seguimiento: control de herida, evitar esfuerzos 2-4 semanas.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 144

Una paciente de 60 años consulta por aumento de volumen en la cara anterior del muslo, en ocasiones doloroso, asociado a náuseas y dolor abdominal. Al examen físico se aprecia dicho aumento de volumen por debajo del ligamento inguinal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Linfoma
B Hernia inguinal
C Adenopatía metastásica
D Hernia femoral
E Sarcoma de partes blandas

Respuesta D. El aumento de volumen ubicado por debajo del ligamento inguinal, asociado a síntomas de obstrucción intestinal (náuseas y dolor abdominal), corresponde a una hernia femoral o crural, mucho más frecuente en mujeres y con el mayor riesgo de estrangulación de todas las hernias de la pared abdominal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 144

Paciente de 60 años consulta por aumento de volumen en la cara anterior del muslo, que en ocasiones es doloroso y se asocia a náuseas y dolor abdominal. Al examen físico se aprecia dicho aumento de volumen por debajo del ligamento inguinal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Linfoma
B Hernia inguinal
C Adenopatía metastásica
D Hernia femoral
E Sarcoma de partes blandas

Respuesta D. Aumento de volumen por debajo del ligamento inguinal, con dolor y síntomas digestivos: hernia femoral, más frecuente en mujeres y con mayor riesgo de complicarse que la inguinal.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 68 años, multípara de 5 hijos, consulta por dolor intenso de 10 horas de evolución en una masa de 2 cm en la ingle derecha, por debajo del ligamento inguinal y medial al pulso femoral, irreductible, con la piel algo enrojecida. Tiene náuseas y el abdomen está distendido con ruidos aumentados. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Intentar reducción manual suave (taxis) en urgencia
B Cirugía de urgencia sin intentar reducirla
C Indicar analgesia y control ecográfico en 48 horas
D Colocar braguero compresivo y observar
E Programar hernioplastia electiva en 6 semanas

Respuesta B. Ubicación bajo el ligamento inguinal y medial a la vena femoral: hernia crural, con signos ya de estrangulación (enrojecimiento, dolor intenso, obstrucción). El taxis está formalmente prohibido; la conducta es cirugía de urgencia.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años, obeso y con tos crónica por EPOC, operado hace 6 días de una laparotomía de urgencia por peritonitis apendicular. Mientras tose con fuerza, siente un dolor agudo en el abdomen. Al revisar la herida, el apósito está empapado de líquido serosanguinolento abundante, y se observan asas de intestino delgado protruyendo a través de la herida, con serosa enrojecida pero viable. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Reintroducir las asas manualmente y cerrar la piel con puntos gruesos
B Cubrir las asas con compresas estériles empapadas en suero tibio y trasladar a pabellón
C Aplicar un vendaje compresivo seco y mantener observación ambulatoria
D Instalar un sistema de aspiración negativa directo sobre las asas expuestas
E Indicar heparina de bajo peso molecular y solicitar un escáner de abdomen

Respuesta B. Es una evisceración aguda, favorecida por la tos crónica y la peritonitis previa. Se cubren las asas con compresas estériles húmedas tibias para evitar su desecación y necrosis, sin intentar reintroducirlas, y se traslada de inmediato a pabellón para el cierre definitivo.

▶ VER CLASE **4.01.1.022** **Hidatidosis hepática** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.4 · Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares

QUÉ HAY QUE SABER

- Echinococcus granulosus; ciclo perro-oveja, endémico en zonas rurales del sur (Araucanía, Aysén, Magallanes). El hígado es el órgano más afectado (~70%).
- Mayoría asintomáticos por años; síntomas por masa (dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia) o complicaciones: rotura a vía biliar (ictericia, colangitis), a peritoneo o tórax, infección del quiste, anafilaxia.
- Diagnóstico: ecografía (clasificación de Gharbi/OMS: quiste con membrana, vesículas hijas, «arena hidatídica») y TAC; serología (ELISA, Western blot) apoya. No puncionar sin protección por riesgo de anafilaxia y siembra.
- Manejo inicial: albendazol 10-15 mg/kg/día (habitual 400 mg c/12 h) perioperatorio; notificar (enfermedad de notificación obligatoria).
- Seguimiento: derivar a cirugía (quistectomía/periquistectomía o PAIR en casos seleccionados). Prevención: no alimentar perros con vísceras crudas y desparasitarlos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 40 años, criador de ovejas en la Región de Aysén, asintomático. En una ecografía solicitada por otro motivo se detecta un quiste hepático de 8 cm con membranas internas desprendidas y vesículas hijas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Punción diagnóstica percutánea del quiste

B Biopsia hepática

C Observación, por estar asintomático

D Metronidazol y drenaje percutáneo

E Albendazol perioperatorio y cirugía

Respuesta E. Un quiste con vesículas hijas en zona ganadera es un quiste hidatídico activo; se apoya con serología. Los quistes grandes o complicados se tratan con cirugía y albendazol antes y después, para reducir el riesgo de siembra. La punción sin protección puede causar anafilaxia y diseminación; la técnica PAIR solo en casos seleccionados.

▶ VER CLASE 4.01.1.023 Quistes y abscesos hepáticos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.4 · Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares

QUÉ HAY QUE SABER

- Quistes simples hepáticos: frecuentes, benignos, anecoicos en ecografía; no requieren seguimiento salvo síntomas por tamaño. Poliquistosis hepática asociada a poliquistosis renal.
- Absceso hepático piógeno: fiebre, dolor en hipocondrio derecho, leucocitosis y elevación de FA; origen biliar (más frecuente), portal (diverticulitis, apendicitis) o hematógeno. Klebsiella, E. coli, anaerobios.
- Absceso amebiano (E. histolytica): hombre joven, viaje a zona endémica, lesión única en lóbulo derecho; serología positiva y responde a metronidazol sin drenaje en la mayoría.
- Diagnóstico: ecografía o TAC con contraste; hemocultivos. Diferencial con quiste hidatídico (no puncionar sin sospecharlo).
- Manejo inicial: antibióticos IV (ceftriaxona + metronidazol) y derivar para drenaje percutáneo guiado por imagen si >5 cm o sin respuesta; buscar y tratar la fuente.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 62 años, diabético, con 10 días de fiebre de 39 °C, calofríos y dolor en hipocondrio derecho. Leucocitos 19.000/mm³ y PCR 220 mg/L. La ecografía muestra una lesión hepática hipoecogénica de 7 cm, de contenido líquido con detritus. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Hepatectomía de urgencia

B Albendazol y cirugía

C Antibióticos orales y control ecográfico en 3 meses

D Antibióticos endovenosos y drenaje percutáneo guiado por imagen

E Observación, ya que es un quiste simple

Respuesta D. Fiebre, dolor en hipocondrio derecho y una colección hepática en un diabético es un absceso hepático piógeno. Se trata con antibióticos endovenosos que cubran gramnegativos y anaerobios, por ejemplo ceftriaxona y metronidazol, más drenaje percutáneo si mide más de 5 cm. Hay que buscar el origen, a menudo biliar.

▶ VER CLASE 4.01.1.024 Tumores hepáticos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.4 · Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares

QUÉ HAY QUE SABER

- Benignos: hemangioma (el más frecuente, hiperecogénico, captación periférica nodular centrípeta en TAC; no se biopsia), hiperplasia nodular focal (cicatriz central) y adenoma (mujer con anticonceptivos, riesgo de rotura y malignización).
- Hepatocarcinoma: sobre hígado cirrótico (VHB, VHC, alcohol, NASH); sospechar con nódulo nuevo en eco de vigilancia o alfafetoproteína elevada. Diagnóstico por imagen (TAC o RM trifásica: captación arterial y lavado portal), sin biopsia.
- Vigilancia del cirrótico: ecografía abdominal ± alfafetoproteína cada 6 meses.
- Metástasis hepáticas son los tumores malignos más frecuentes del hígado (colon, mama, pulmón, páncreas); buscar primario.
- Manejo inicial: estudio con TAC/RM y marcadores; suspender anticonceptivos en adenoma. Seguimiento: derivar a cirugía hepatobiliar/gastroenterología (resección, ablación, quimioembolización, trasplante según criterios de Milán).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 63 años con cirrosis hepática por alcohol, en seguimiento con ecografía semestral, presenta un nódulo hepático nuevo de 3 cm. La TAC trifásica muestra captación intensa de contraste en fase arterial y lavado en las fases portal y tardía. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hemangioma hepático

B Hiperplasia nodular focal

C Metástasis de cáncer colorrectal

D Hepatocarcinoma

E Absceso hepático

Respuesta D. En un paciente cirrótico, un nódulo mayor de 1 cm con hiperrealce arterial y lavado en fase portal o tardía es diagnóstico de hepatocarcinoma por imagen, sin necesidad de biopsia. El hemangioma muestra relleno periférico globular centrípeto, y la hiperplasia nodular focal aparece en mujeres jóvenes con hígado sano.

▶ VER CLASE 4.01.1.025 Colecistitis crónica

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.2 · Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap

QUÉ HAY QUE SABER

- Colelitiasis sintomática: cólico biliar (dolor en epigastrio o hipocondrio derecho tras comidas grasas, 30 min a <6 h, irradiado a dorso o escápula derecha) sin fiebre ni leucocitosis, con episodios recurrentes.
- Colecistitis crónica es un diagnóstico histológico (inflamación crónica por litiasis); clínicamente equivale a colelitiasis sintomática. Dispepsia por grasas no es específica.
- Diagnóstico específico: ecografía abdominal (cálculos móviles con sombra acústica posterior, pared engrosada); pruebas hepáticas para descartar coledocolitiasis.
- Manejo inicial del cólico: analgesia con AINE (ketorolaco 30 mg IV/IM o diclofenaco) y antiespasmódico, régimen sin grasas.
- Seguimiento: derivar a cirugía para colecistectomía laparoscópica electiva. GES: colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 a 49 años con colelitiasis.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 42 años refiere, desde hace 1 año, episodios recurrentes de dolor en el hipocondrio derecho después de comidas copiosas, de 2 a 3 horas de duración, que ceden espontáneamente. Actualmente está asintomática. La ecografía muestra múltiples cálculos vesiculares y pared de 4 mm, sin dilatación de la vía biliar. Pruebas hepáticas normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Colecistectomía laparoscópica electiva

B Ácido ursodesoxicólico por 6 meses

C Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

D Control ecográfico anual

E Hospitalizar e iniciar antibióticos

Respuesta A. Los cólicos biliares recurrentes con colelitiasis corresponden a una colecistitis crónica litiásica sintomática; el tratamiento es la colecistectomía laparoscópica electiva, que previene complicaciones como colecistitis aguda, coledocolitiasis y pancreatitis. El ácido ursodesoxicólico tiene baja eficacia y alta recurrencia, y la CPRE solo se indica si hay coledocolitiasis.

▶ VER CLASE 4.01.1.026 Ictericia obstructiva

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.1 · Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Ictericia obstructiva (colestasia extrahepática): ictericia con coluria, acolia y prurito; predominio de bilirrubina directa con FA y GGT elevadas.
- Causas: coledocolitiasis (ictericia fluctuante con dolor), cáncer de cabeza de páncreas/periampular (ictericia indolora progresiva, signo de Courvoisier-Terrier: vesícula palpable no dolorosa), colangiocarcinoma, cáncer de vesícula, estenosis benigna.
- Diagnóstico específico: ecografía primero (vía biliar dilatada: colédoco >6-8 mm); luego colangio-RM, endosonografía o TAC según sospecha; CPRE diagnóstica y terapéutica.
- Bandera roja: fiebre, ictericia y dolor (tríada de Charcot) = colangitis, urgencia; prolongación del TP por déficit de vitamina K.
- Manejo inicial: hidratación, vitamina K parenteral si TP alterado, antibióticos si colangitis. Seguimiento: derivar a gastroenterología/cirugía para CPRE o cirugía según la causa.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · CASO REPRESENTATIVO · BANCO EUNACOM

Mujer de 55 años con dolor cólico en hipocondrio derecho e ictericia de 2 días, sin fiebre. Bilirrubina 4 mg/dL de predominio directo, FA y GGT elevadas, transaminasas levemente altas. Ecografía: colelitiasis y vía biliar de 9 mm, sin cálculos visibles en el colédoco. **¿Cuál es el siguiente examen?**

A CPRE directa

B Colangiorresonancia

C TAC de abdomen con contraste

D Biopsia hepática percutánea

E Repetir la ecografía en 48 horas

Respuesta B. Colestasia con dolor y sin fiebre: coledocolitiasis. La ecografía ve la vía dilatada pero no el cálculo, así que se confirma con colangiorresonancia antes de la CPRE (invasiva, con riesgo de pancreatitis). Directo a CPRE solo si hay colangitis o si la eco ya vio el cálculo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 161

Paciente que empieza con ictericia 7 días post colecistectomía:

A Litiasis en vía biliar común

B Lesión vía biliar iatrogénica

C Ninguna de las anteriores es correcta

D Todas las anteriores son correctas

E No se dispone de información suficiente

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Lesión vía biliar iatrogénica). La evaluación preanestésica tiene como objetivo evaluar y minimizar los riesgos, evaluar la vía aérea y elegir el tipo de anestesia y fármacos.

▶ VER CLASE 4.01.1.027 Litiasis biliar

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.2 · Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap

QUÉ HAY QUE SABER

- Colelitiasis: muy prevalente en Chile (mujeres, población mapuche, obesidad, multiparidad, baja rápida de peso); la mayoría asintomática. Cálculos de colesterol los más frecuentes.
- Cuadros: cólico biliar, colecistitis aguda, coledocolitiasis, colangitis, pancreatitis biliar e íleo biliar (obstrucción por cálculo en íleon, neumobilia en Rx).
- Diagnóstico específico: ecografía abdominal (imagen hiperecogénica móvil con sombra acústica). Sospecha de coledocolitiasis: pruebas hepáticas alteradas, colédoco dilatado → colangio-RM o CPRE.
- Manejo inicial: analgesia del cólico (AINE), régimen hipograso; antibióticos y hospitalización si colecistitis o colangitis.
- Seguimiento: derivar a cirugía; colecistectomía en sintomáticos y GES colecistectomía preventiva en 35-49 años (prevención de cáncer de vesícula). Asintomáticos fuera de ese grupo: individualizar (cálculos >3 cm, vesícula en porcelana, pólipo >1 cm).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 125

Paciente de 40 años, IMC 30, presenta episodios de dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho desde hace 3 meses, que ceden espontáneamente luego de algunos minutos. Se realiza una ecografía, que muestra imágenes hiperecogénicas dentro de la vesícula con sombra acústica posterior, pared delgada y sin líquido perivesicular. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Colelitiasis

B Coledocolitiasis

C Colecistitis crónica

D Cáncer de vesícula

E Colecistitis aguda

Respuesta A. Cólicos biliares que ceden solos en minutos a horas, sin fiebre ni signos inflamatorios, con cálculos y sombra acústica en la ecografía: colelitiasis sintomática. Corresponde programar colecistectomía electiva. Sin pared engrosada ni líquido perivesicular no es colecistitis aguda.

▶ VER CLASE 4.01.1.028 Cáncer de vesícula y vías biliares

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.4 · Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares

QUÉ HAY QUE SABER

- Chile tiene de las tasas más altas del mundo de cáncer de vesícula, sobre todo mujeres mapuche del sur; principal factor de riesgo: colelitiasis de larga data (cálculos grandes), vesícula en porcelana, pólipos >1 cm.
- Frecuentemente hallazgo en biopsia de colecistectomía; en etapa avanzada: dolor en hipocondrio derecho, baja de peso, ictericia, masa palpable.
- Colangiocarcinoma: ictericia obstructiva indolora progresiva; tumor de Klatskin en la confluencia hiliar (vesícula no palpable). CA 19-9 apoya.
- Estudio: ecografía, TAC trifásica, colangio-RM. Prevención: GES colecistectomía preventiva en colelitiasis entre 35 y 49 años.

- Manejo inicial: drenaje biliar si colangitis, soporte nutricional y vitamina K. Seguimiento: derivar a cirugía hepatobiliar/oncología (colecistectomía extendida, resección; paliación con stent).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 95

Paciente de 60 años se realiza una colecistectomía laparoscópica electiva por colelitiasis. La biopsia informa adenocarcinoma invasor en el fondo vesicular, que compromete hasta la subserosa. Una TAC de abdomen y pelvis con contraste no muestra metástasis. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Quimioterapia
B Radioterapia
C Cuidados paliativos
D Control con TAC cada 3 meses
E Colecistectomía radical

Respuesta E. En un cáncer de vesícula incidental T1b o mayor (aquí T2, subseroso) sin enfermedad a distancia, está indicada la reintervención con colecistectomía radical o extendida: resección del lecho hepático y linfadenectomía, que mejora la sobrevida. Solo el T1a, limitado a la lámina propia, se considera tratado con la colecistectomía simple.

▶ VER CLASE 4.01.1.029 Pancreatitis crónica

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 4.2 · Pancreatitis Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Daño pancreático irreversible con fibrosis; causa principal alcohol (también tabaco, genética, obstrucción, hipertrigliceridemia, autoinmune).
- Clínica: dolor epigástrico recurrente o crónico irradiado al dorso, que empeora con comidas; insuficiencia exocrina (esteatorrea, baja de peso) y endocrina (diabetes pancreatogénica, tipo 3c) en etapas tardías.
- Diagnóstico: TAC (calcificaciones pancreáticas, dilatación del Wirsung, atrofia); Rx de abdomen puede mostrar calcificaciones. Elastasa fecal baja confirma insuficiencia exocrina. Lipasa puede ser normal.
- Manejo inicial: suspender alcohol y tabaco, analgesia escalonada, enzimas pancreáticas con las comidas, dieta fraccionada, suplementar vitaminas liposolubles, tratar diabetes.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología/cirugía; complicaciones: pseudoquiste, estenosis biliar o duodenal, trombosis esplénica y mayor riesgo de cáncer de páncreas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 50 años, con consumo excesivo de alcohol desde hace 15 años, consulta por dolor epigástrico crónico irradiado al dorso, baja de peso de 8 kg y deposiciones abundantes, aceitosas y fétidas. Glicemia en ayunas de 160 mg/dL. La TAC muestra calcificaciones pancreáticas difusas y un conducto pancreático irregular. **Además de suspender el alcohol y el tabaco, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para la esteatorrea?**

A Dieta sin gluten
B Enzimas pancreáticas junto con las comidas
C Metronidazol
D Octreotide
E Pancreatectomía total

Respuesta B. Dolor, esteatorrea y diabetes con calcificaciones pancreáticas definen una pancreatitis crónica con insuficiencia exocrina y endocrina. La esteatorrea se trata con enzimas pancreáticas administradas junto con las comidas. La dieta sin gluten trata la enfermedad celíaca, que no explica las calcificaciones.

▶ VER CLASE 4.01.1.030 Cáncer de páncreas y otros tumores preampulares

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.1 · Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumores periampulares: cáncer de cabeza de páncreas (el más frecuente), ampolla de Vater, colédoco distal y duodeno; los ampulares tienen mejor pronóstico (síntomas precoces).
- Clínica: ictericia indolora progresiva, prurito, coluria, acolia, baja de peso; signo de Courvoisier-Terrier (vesícula palpable no dolorosa). Ampuloma: ictericia fluctuante, anemia y melena.
- Estudio: ecografía (vía biliar dilatada sin cálculos), TAC de abdomen con protocolo de páncreas, endosonografía con biopsia, CA 19-9 (seguimiento, no diagnóstico).
- Manejo inicial: vitamina K si TP prolongado, manejo de prurito, nutrición; drenaje biliar (CPRE con stent) si colangitis o retraso quirúrgico.
- Seguimiento: derivar a cirugía hepatobiliopancreática para pancreatoduodenectomía (Whipple) en resecables; paliación endoscópica y quimioterapia en el resto.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 66 años presenta ictericia progresiva e indolora de 1 mes, coluria, acolia, prurito y baja de peso de 7 kg. Al examen se palpa una vesícula distendida e indolora. La TAC con contraste muestra un tumor de 2 cm en la región periampular, sin compromiso vascular ni metástasis. **¿Cuál es la cirugía con intención curativa?**

A Colecistectomía

B Pancreatoduodenectomía (operación de Whipple)

C Derivación biliodigestiva

D Pancreatectomía distal con esplenectomía

E Prótesis biliar por CPRE

Respuesta B. Los tumores periampulares (cabeza de páncreas, ampolla de Vater, colédoco distal y duodeno) se presentan con ictericia indolora y vesícula palpable (Courvoisier-Terrier). Si son resecables, el tratamiento curativo es la pancreatoduodenectomía. La derivación biliodigestiva y la prótesis son paliativas; la pancreatectomía distal es para tumores de cuerpo y cola.

▶ VER CLASE 4.01.1.031 Cáncer de páncreas

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.1 · Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Adenocarcinoma ductal de páncreas: mal pronóstico (sobrevida a 5 años <10%); factores: tabaco (principal modificable), edad, pancreatitis crónica, obesidad, diabetes de reciente inicio, antecedentes familiares.
- Cabeza (70%): ictericia indolora, Courvoisier-Terrier, baja de peso. Cuerpo y cola: dolor epigástrico irradiado al dorso, baja de peso, diagnóstico tardío. Signo de Trousseau (tromboflebitis migratoria).
- Diabetes de reciente inicio en adulto mayor delgado con baja de peso debe hacer sospechar cáncer de páncreas.
- Estudio: TAC trifásico de páncreas (lesión hipodensa) y CA 19-9; endosonografía con punción para histología.
- Manejo inicial: drenaje biliar y analgesia (incluyendo opioides, bloqueo del plexo celíaco). Seguimiento: derivar a cirugía/oncología; solo ~20% es resecable (Whipple, pancreatectomía distal).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 70 años, fumador, consulta por ictericia indolora de 3 semanas, prurito, baja de peso de 6 kg y diabetes diagnosticada hace 4 meses. La ecografía muestra dilatación de la vía biliar intra y extrahepática y del conducto de Wirsung, sin cálculos. **¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?**

A Biopsia hepática percutánea

B CPRE diagnóstica

C Cintigrafía hepatobiliar

D TAC de abdomen trifásica con protocolo de páncreas

E Repetir la ecografía en 1 mes

Respuesta D. Ictericia indolora con dilatación de colédoco y Wirsung (signo del doble conducto), baja de peso y diabetes de reciente inicio en un fumador mayor sugieren cáncer de cabeza de páncreas. La TAC trifásica es el examen de elección para diagnosticar, etapificar y evaluar resecabilidad. La CPRE es terapéutica y no se usa para el diagnóstico inicial.

▶ VER CLASE 4.01.1.032 Masa cervical y tumores del cuello

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.20 · Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

QUÉ HAY QUE SABER

- Por edad: <40 años predominan inflamatorias/congénitas (adenitis reactiva, quiste tirogloso en línea media que asciende con la protrusión lingual, quiste branquial lateral); >40 años, una masa cervical persistente es maligna hasta demostrar lo contrario.
- Banderas rojas: >2 semanas sin regresión, >1,5-2 cm, dura, fija, indolora, supraclavicular, con disfonía, disfagia, otalgia refleja, baja de peso o fumador/bebedor.
- Adenopatía metastásica de carcinoma escamoso de cabeza y cuello: buscar primario con examen ORL completo (nasofibroscopía). Supraclavicular izquierda (Virchow): primario abdominal.
- Estudio: ecografía cervical, punción con aguja fina, TAC de cuello; evitar biopsia excisional antes del estudio ORL en sospecha de metástasis escamosa (salvo sospecha de linfoma).
- Adenitis reactiva: observar 2-3 semanas o antibiótico si signos bacterianos. Seguimiento: derivar a cirugía de cabeza y cuello/ORL toda masa persistente o sospechosa.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 80

Adulto joven con una masa blanda palpable en la línea media del cuello, entre el mentón y el cartílago tiroides. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Adenoma tiroideo
B Quiste tirogloso
C Quiste branquial
D Linfadenitis cervical
E Lipoma cervical

Respuesta B. El quiste tirogloso es la masa congénita más frecuente de la línea media del cuello; se ubica habitualmente a nivel o bajo el hueso hioides, por encima del tiroides, y asciende al protruir la lengua o deglutir. El quiste branquial, en cambio, es lateral, anterior al borde del esternocleidomastoideo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 116

Un paciente de 25 años de edad, sin patologías previas, presenta desde hace 4 años aumento de volumen cervical lateral, que ha ido creciendo. Al examen se constata una masa palpable, de 3 cm, en la zona lateral del cuello, de ubicación submandibular. Se solicita una ecografía cervical, que muestra un nódulo hipoecogénico, de bordes bien delimitados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Nódulo tiroideo
B Quiste branquial
C Quiste tirogloso
D Linfadenopatía tuberculosa
E Tumor de glándula salival secundaria

Respuesta B. Es un quiste branquial clásico (zona lateral del cuello y crecimiento muy lento). No puede ser nódulo tiroideo, por la ubicación (la tiroides está en la zona media inferior del cuello). Tampoco un quiste del conducto tirogloso, porque este es de la línea media. La adenopatía tuberculosa o escrófula crece más rápido y suele fistulizarse, dando salida a material caseoso.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 47

Niño de 4 años con masa cervical anterior en la línea media, móvil con la deglución y la protrusión de la lengua, sin dolor ni fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?

A Quiste tirogloso; derivar a cirugía para extirpación electiva
B Adenopatía cervical reactiva; observar
C Linfoma cervical; biopsia
D Bocio difuso; solicitar TSH
E Quiste braquial; observar

Respuesta A. Masa cervical anterior en línea media que sube con deglución y protrusión lingual = quiste tirogloso. Tratamiento: cirugía de Sistrunk (extirpación del quiste + cuerpo del hioides) para evitar recidivas.

▶ VER CLASE 4.01.1.033 **Cáncer del tiroides** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.10 · Cáncer de Tiroides: Subtipos Histológicos y Manejo Oncológico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante nódulo tiroideo con crecimiento rápido, consistencia dura, fijo, adenopatías cervicales, disfonía, antecedente de irradiación cervical o familiar con cáncer tiroideo/MEN2.
- Papilar (80-85%, buen pronóstico, diseminación linfática), folicular (hematógena), medular (células C, calcitonina, MEN2, RET) y anaplásico (adulto mayor, muy agresivo).
- Estudio: TSH y ecografía tiroidea (TI-RADS: hipoecogénico, microcalcificaciones, bordes irregulares, más alto que ancho); punción con aguja fina (citología Bethesda) según tamaño y TI-RADS.
- Bethesda V-VI: cirugía; Bethesda III-IV: repetir PAAF, estudio molecular o lobectomía diagnóstica.
- Seguimiento: derivar a cirugía de cabeza y cuello/endocrinología (tiroidectomía total o lobectomía, radioyodo según riesgo, supresión de TSH y tiroglobulina como marcador). GES: cáncer diferenciado y medular de tiroides en adultos.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una paciente de 45 años, previamente operada de tiroidectomía total y dosis ablativa de I-131 hace 2 años por un carcinoma papilar de tiroides, asiste a control anual de seguimiento oncológico. **¿Cuál es el examen de laboratorio principal que se debe solicitar en sangre para pesquisar precozmente una recidiva tumoral?**

A Calcitonina sérica basal
B Tiroglobulina sérica en conjunto con anticuerpos anti-tiroglobulina
C Antígeno carcinoembrionario (CEA)
D TSH y T3 total
E Fosfatasas alcalinas óseas

Respuesta B. En el carcinoma diferenciado tratado con tiroidectomía total y ablación, la tiroglobulina debe quedar indetectable (menor de 0,2 ng/mL); si reaparece o sube, indica recidiva. Se pide siempre con anticuerpos anti-tiroglobulina, porque estos pueden dejarla falsamente baja.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 38 años presenta un nódulo tiroideo de 2.5 cm cuya biopsia por punción confirma un Carcinoma Medular de Tiroides. El paciente refiere que su padre falleció a los 45 años por una causa no precisada asociada a crisis de cefalea e hipertensión severa. **Previo a programar la cirugía de resección cervical, ¿cuál es la conducta diagnóstica de máxima prioridad que debe llevarse a cabo?**

A Indicar una dosis terapéutica inmediata de radioyodo I-131

B Descartar la coexistencia de un feocromocitoma mediante metanefrinas plasmáticas o urinarias y realizar estudio genético de la mutación del protooncogén RET

C Administrar quimioterapia con cisplatino para reducir la masa antes de la tiroidectomía

D Indicar levotiroxina a dosis altas para suprimir la TSH a valores menores a 0.01 mIU/L

E Solicitar una cintigrafía con yodo radiactivo de cuerpo entero

Respuesta B. El 25 % de los carcinomas medulares es hereditario (NEM 2A o 2B, mutación RET). Antes de operar el cuello hay que descartar un feocromocitoma con metanefrinas: si no se detecta, la anestesia puede gatillar una crisis adrenérgica fatal. Si existe, se reseca antes que la tiroides.

▶ VER CLASE 4.01.1.034 Patología benigna del tiroides

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.7 · Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía

QUÉ HAY QUE SABER

- Nódulo tiroideo: muy frecuente (ecografía en ~50% de adultos), 90-95% benigno. Primer paso: TSH; si está suprimida, cintigrafía (nódulo caliente hiperfuncionante casi nunca maligno).
- Ecografía tiroidea con clasificación TI-RADS y PAAF según tamaño y patrón (en general ≥1 cm si sospechoso, ≥1,5-2,5 cm si bajo riesgo). Citología Bethesda II: benigno, control ecográfico.
- Bocio multinodular: frecuentemente eutiroideo; indicaciones quirúrgicas: compresión (disfagia, disnea, estridor), extensión endotorácica, sospecha de malignidad o hipertiroidismo (bocio tóxico).
- Tiroiditis subaguda (De Quervain): dolor tiroideo post viral, VHS elevada, captación baja; AINE o prednisona y betabloqueo. Hipertiroidismo: propranolol + metimazol; Graves puede requerir radioyodo o cirugía.
- Seguimiento completo: nódulo benigno con ecografía a los 12-24 meses; repetir PAAF si crece >50% en volumen o aparecen rasgos sospechosos. Derivar a cirugía si compresión o sospecha.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Paciente de 42 años con bocio multinodular tóxico de 45 g, sin síntomas compresivos, con paridad completa y sin deseo de embarazo. Se le propone tratamiento ablativo con radioyodo. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a esta terapia es correcta?**

A La probabilidad de remisión completa sin requerir levotiroxina es superior al 95 %

B El resultado esperado más frecuente a largo plazo es el hipotiroidismo permanente, que requiere suplementación de por vida

C Puede amamantar sin restricciones a su hijo lactante el día posterior al radioyodo

D El radioyodo está contraindicado porque el bocio multinodular responde solo a tiamazol de por vida

E Debe asociarse a dosis altas de aspirina para potenciar la fijación del isótopo

Respuesta B. Más del 80 % de los pacientes tratados con radioyodo desarrolla hipotiroidismo permanente: no es un fracaso, sino la consecuencia esperada de la ablación. Requiere controles de TSH y levotiroxina de por vida. La lactancia es contraindicación absoluta, y el BMNT no remite con fármacos.

▶ VER CLASE 4.01.1.035 Cáncer de mama

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.14 · Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer más frecuente y primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile. Factores: edad, mutación BRCA1/2, antecedente familiar, menarquia precoz/menopausia tardía, nuliparidad, TRH, obesidad, alcohol, radiación torácica.
- Sospecha: nódulo duro, indoloro, irregular, fijo; retracción de piel o pezón, piel de naranja, secreción sanguinolenta unilateral uniorificial, adenopatía axilar. Cáncer inflamatorio: mama eritematosa y edematosa sin fiebre.
- Estudio: mamografía bilateral (BI-RADS) + ecografía; en <35 años, ecografía primero. Confirmación con biopsia core (trucut). BI-RADS 4-5 requiere biopsia.
- GES cáncer de mama (≥15 años): confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento con plazos garantizados ante sospecha. Pesquisa con mamografía en el examen de medicina preventiva de mujeres de 50 a 59 años cada 3 años.
- Seguimiento: derivar a unidad de patología mamaria; tratamiento según etapa y receptores (RE/RP, HER2): cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, trastuzumab.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 178

Una paciente de 41 años presenta un nódulo mamario derecho, de 2 cm de diámetro, que se autopalpó hace 2 meses. Al examen físico tiene consistencia dura e irregular. Cuenta con una mamografía, que es informada como BI-RADS 4. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Controlar con nueva mamografía en 1 año
B Solicitar ecotomografía mamaria
C Solicitar resonancia magnética de mama
D Realizar biopsia con aguja gruesa
E Realizar biopsia estereotáxica

Respuesta E. BI-RADS 4 se biopsia siempre. Con aguja gruesa si el nódulo es palpable, o estereotáxica si no lo es; ambas son aceptables, pero la estereotáxica suele ser más fidedigna cuando el caso lo permite.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 153

Una mujer de 45 años se realiza una mamografía, que muestra microcalcificaciones agrupadas y espiculadas en el cuadrante superior externo de la mama derecha, de 2 cm de diámetro. Su examen mamario no tiene alteraciones y cuenta con una mamografía previa, de hace 2 años, informada como BI-RADS 2. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Pedir ecotomografía mamaria
B Realizar biopsia con aguja gruesa
C Programar biopsia estereotáxica
D Solicitar resonancia magnética mamaria
E Realizar control mamográfico en un año

Respuesta C. Las microcalcificaciones agrupadas y espiculadas corresponden a un BI-RADS 4 a 5 actual, sin importar que hace 2 años fuera BI-RADS 2. Como el examen mamario es normal, la lesión no es palpable, así que la biopsia se hace guiada por estereotaxia, no con aguja gruesa a mano alzada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 27

Mujer de 60 años presenta aumento de volumen en la axila derecha, de 4 cm de diámetro, indoloro, de consistencia dura y adherido a planos profundos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hidrosadenitis
B Cáncer de mama
C Cáncer de pulmón
D Lipoma
E Tuberculosis ganglionar

Respuesta B. Una adenopatía axilar dura, indolora y fija en una mujer de 60 años corresponde, hasta demostrar lo contrario, a metástasis de un cáncer de mama, aunque no se palpe el tumor primario. Debe estudiarse con mamografía, ecografía y biopsia. La hidrosadenitis es dolorosa y supurativa, y el lipoma es blando y móvil.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 173

Una mujer de 52 consulta por molestias en la mama izquierda de 4 meses de evolución, caracterizados por eritema y prurito en el pezón y la aréola. Al examen físico se ve lo siguiente (Nota: aréola y pezón están eritematosos): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Enfermedad de Paget de la mama
B Mastitis candidiásica
C Cáncer inflamatorio de la mama
D Papiloma del pezón
E Eccema del pezón

Respuesta A. Diagnóstico: Enfermedad de Paget de la mama (opción A). El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile, seguido del cáncer gástrico y de pulmón.

▶ VER CLASE 4.01.1.036 Patología mamaria benigna

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.14 · Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Fibroadenoma: mujer joven (15-35 años), nódulo móvil, elástico, bien delimitado, indoloro; ecografía con nódulo sólido ovalado de bordes nítidos. Biopsia si >2-3 cm, crecimiento o edad >35 años.
- Cambios fibroquísticos: mastalgia cíclica premenstrual y nodularidad bilateral; quiste simple anecoico en eco se puede puncionar si es sintomático (líquido no hemático no requiere citología).
- Mastitis puerperal (S. aureus): dolor, eritema y fiebre en lactancia; continuar lactancia, vaciamiento y cloxacilina o cefadroxilo 10-14 días. Absceso: drenaje (punción guiada o incisión).
- Telorrea: bilateral y multiorificial suele ser fisiológica/hormonal (descartar hiperprolactinemia); unilateral, uniorificial, espontánea o sanguinolenta → papiloma intraductal vs carcinoma, estudiar.

- Seguimiento completo en APS: fibroadenoma estable con ecografía en 6 meses; derivar a patología mamaria lesiones BI-RADS 4-5, nódulos con cambios o masa en mujer mayor.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 45

Puérpera de 10 días con dolor y aumento de volumen en la mama derecha. La mama tiene eritema, una masa fluctuante y dolorosa de 6 centímetros, con afectación de la piel y secreción purulenta que sale por una lesión cutánea al comprimir. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Antibióticos de amplio espectro por vía oral

B Realizar drenaje quirúrgico de la lesión

C Realizar drenaje por punción

D Realizar extracción láctea

E Aplicar calor local y antiinflamatorios orales

Respuesta B. Absceso mamario con compromiso y necrosis de la piel, y secreción purulenta ya exteriorizada: aquí el drenaje quirúrgico con incisión es de elección por sobre la punción, que se reserva para cuando la piel está sana.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 50

Mujer de 35 años presenta un nódulo mamario desde hace 8 meses. La ecografía mamaria muestra un tumor de aspecto sólido, de bordes bien delimitados, sin refuerzo posterior, clasificado como BI-RADS 3. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Mastopatía fibroquística

B Papiloma ductal

C Fibroadenoma

D Tumor phyllodes

E Carcinoma ductal

Respuesta C. Un nódulo sólido, bien delimitado y probablemente benigno (BI-RADS 3) en una mujer joven corresponde con mayor probabilidad a un fibroadenoma, el tumor benigno de mama más frecuente entre los 15 y 35 años. El tumor phyllodes es mucho menos frecuente, de crecimiento rápido y mayor tamaño.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 176

Una mujer de 22 años consulta por un nódulo mamario, que se autopalpó. Al examen físico se constata un nódulo en la mama derecha, de 2 cm de diámetro, móvil. No se palpan adenopatías axilares. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de esta paciente?

A Mamografías

B Ecografía mamaria

C Resonancia magnética nuclear de mamas

D TAC de tórax

E Biopsia

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Ecografía mamaria). Es un fibroadenoma clásico, que se estudia con ecografía mamaria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 7

Una paciente de 30 años, con antecedente de un quiste mamario izquierdo, consulta por dolor en la mama izquierda, asociada a fiebre y eritema. Al examen físico se constata eritema, aumento de volumen y dolor en la mama izquierda, con un nódulo doloroso a la palpación. Se solicita una ecografía que muestra una imagen quística de 5 cm de diámetro, con signos inflamatorios en las partes blandas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar seguimiento ecográfico

B Iniciar tratamiento con AINES

C Realizar punción y drenaje

D Drenar mediante cirugía

E Solicitar resonancia magnética nuclear de mamas

Respuesta D. Es un absceso mamario, que se debe drenar en pabellón. Además, se deben dar antibióticos (cloxacilina o cefazolina). En cambio, el flegmón mamario y las mastitis no abscedadas, solo se tratan con antibióticos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 155

Mujer joven con nódulo mamario de 5 cm, móvil, blando, sensible. Ecografía BIRADS-US 2. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Biopsia core guiada por ecografía

B Ecotomografía de control en 6 meses

C Mamografía bilateral

D Resonancia magnética mamaria

E Exéresis quirúrgica

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Ecotomografía de control en 6 meses (opción B). Ecotomografía de control en 6 meses. Es el método diagnóstico de elección debido a su alta sensibilidad (>95%) y capacidad para evaluar complicaciones y extensión anatómica con precisión milimétrica antes de decidir la terapéutica invasiva.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 77

Una paciente de 25 años, con antecedente de un quiste mamario de dos centímetros, en la mama derecha, diagnosticado hace 2 años. Consulta ahora por dolor y aumento de volumen, en relación a la mama derecha. Al examen físico tiene fiebre de 38,6°C, más una zona aumentada de volumen, con eritema y aumento de la temperatura, en la mama derecha, mayor en la zona superoexterna. Se solicita una ecografía mamaria, que visualiza signos inflamatorios de las partes blandas, más la lesión quística de 5 cm de diámetro, con contenido irregular. La conducta más adecuada es:

A Punción del quiste
B Solicitar resonancia magnética de mama
C Drenaje quirúrgico
D Realizar biopsia con aguja gruesa
E Control mamográfico

Respuesta C. Tiene un absceso mamario, como complicación de un quiste infectado. Se debe drenar y manejar con antibióticos. El drenaje es quirúrgico, con incisión y drenaje.

▶ VER CLASE 4.01.1.037 Hidatidosis pulmonar

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 4.4 · Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Hidatidosis pulmonar: segunda localización de E. granulosus (~20-30%), más frecuente en niños; zonas rurales del sur de Chile.
- Quiste íntegro suele ser asintomático (hallazgo en Rx: imagen redonda, homogénea, bien delimitada). Complicado: tos, hemoptisis, vómica de líquido salado con membranas (hidatidoptisis), fiebre, anafilaxia.
- Signos radiológicos de rotura: «camalote» o membrana flotante, signo del menisco/doble arco. Ecografía abdominal para buscar quistes hepáticos concomitantes.
- Diagnóstico: Rx y TAC de tórax + serología; no puncionar.
- Manejo inicial: albendazol perioperatorio; tratamiento de soporte en complicación. Seguimiento: derivar a cirugía de tórax (quistectomía con capitonaje conservando parénquima). Notificación obligatoria.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 35 años, de zona rural de la Región de La Araucanía, consulta por tos y dolor torácico. La radiografía de tórax muestra una imagen redondeada de 7 cm, de bordes nítidos, en el lóbulo inferior derecho. La serología para hidatidosis es positiva. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Albendazol como tratamiento exclusivo
B Punción y aspiración percutánea del quiste
C Neumonectomía derecha
D Observación con radiografía semestral
E Cirugía conservadora (quistectomía con capitonaje) asociada a albendazol

Respuesta E. El quiste hidatídico pulmonar se trata con cirugía conservadora del parénquima (quistectomía o periquistectomía, cierre de bronquios y capitonaje), con albendazol perioperatorio para reducir siembra y recurrencia. La punción percutánea del quiste pulmonar está contraindicada por riesgo de anafilaxia y siembra, y las resecciones extensas son innecesarias.

▶ VER CLASE 4.01.1.038 Nódulo pulmonar solitario

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.1 · Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner

QUÉ HAY QUE SABER

- Nódulo pulmonar solitario: opacidad redondeada ≤3 cm rodeada de parénquima normal, sin atelectasia ni adenopatías; >3 cm se llama masa (alta probabilidad de malignidad).
- Sugieren malignidad: edad >50, tabaquismo, tamaño >8 mm, bordes espiculados, crecimiento, lóbulo superior, antecedente de cáncer. Benignidad: calcificación central, laminar o en «palomita de maíz» (hamartoma), estabilidad ≥2 años (sólidos).
- Primer paso: comparar con radiografías previas y realizar TAC de tórax.
- Conducta según tamaño y riesgo (guías Fleischner): <6 mm bajo riesgo sin control; 6-8 mm TAC de control; >8 mm PET-CT, biopsia o resección.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar/cirugía de tórax todo nódulo sospechoso o >8 mm; en Chile considerar TBC, hidatidosis y micosis como diferenciales.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 55 años, fumador de 25 paquetes-año, asintomático. Una TAC de tórax pedida por otro motivo muestra un nódulo sólido de 7 mm en el lóbulo superior derecho, de bordes lisos, sin calcificaciones. No tiene imágenes previas en ningún centro. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A No requiere seguimiento

B TAC de control a los 6 a 12 meses y luego a los 18 a 24 meses

C PET-CT con 18-FDG

D Biopsia percutánea guiada por TAC

E Lobectomía superior derecha

Respuesta B. Sin imágenes previas para comparar, el tamaño manda: un nódulo de 6 a 8 mm se controla con TAC a los 6–12 meses y luego a los 18–24 meses, buscando crecimiento. El PET-CT y la biopsia se reservan para nódulos mayores de 8 mm.

▶ VER CLASE 4.01.1.039 Cáncer pulmonar

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.2 · Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

QUÉ HAY QUE SABER

- Principal causa de muerte por cáncer en Chile; factor de riesgo dominante: tabaquismo (también arsénico en agua del norte, asbesto, radón). Tipos: adenocarcinoma (el más frecuente), escamoso, células grandes y células pequeñas (neuroendocrino, muy agresivo).
- Sospecha: tos persistente o cambio de la tos en fumador, hemoptisis, baja de peso, disnea, neumonía que no resuelve, dolor torácico, disfonía (recurrente) o hipocratismo digital.
- Síndromes asociados: Pancoast (Horner, dolor de hombro/brazo), vena cava superior, paraneoplásicos (SIADH e hipercortisolismo en células pequeñas; hipercalcemia por PTHrp en escamoso).
- Estudio: Rx tórax y TAC de tórax con contraste; confirmación histológica por fibrobroncoscopía, punción transtorácica o EBUS; etapificación con PET-CT y RM cerebral.
- Manejo inicial: cesación tabáquica, manejo sintomático. Seguimiento: derivar a broncopulmonar/oncología; cirugía en etapas I-II de no células pequeñas; terapias blanco según mutaciones (EGFR, ALK).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 67 años, fumador de 45 paquetes-año, consulta por astenia, náuseas, constipación y confusión fluctuante, sin fiebre. Radiografía: masa central perihiliar derecha de 5 cm con ensanchamiento mediastínico. Calcio 13,8 mg/dL, fósforo 2,1 mg/dL, PTH suprimida y PTHrP marcadamente elevada. **¿Cuál es el tipo histológico más probable?**

A Adenocarcinoma periférico

B Carcinoma epidermoide (escamoso)

C Carcinoma microcítico

D Carcinoma de células grandes

E Metástasis óseas de un adenocarcinoma

Respuesta B. Masa central en fumador con hipercalcemia grave, PTH suprimida y PTHrP elevada: hipercalcemia humoral por PTHrP, firma del carcinoma epidermoide. Manejo inmediato: hidratación con suero fisiológico, bifosfonato EV (ácido zoledrónico) y fibrobroncoscopía con biopsia.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 59 años, tabáquico, consulta por dolor intenso de hombro derecho y cara interna del antebrazo derecho, asociado a caída del párpado superior derecho y ausencia de sudoración en la mitad derecha del rostro. La radiografía de tórax muestra una opacidad apical en el vértice pulmonar derecho. **¿Cómo se denomina esta constelación clínica y cuál es su sustrato anatómico?**

A Síndrome de Kartagener por alteración de la motilidad ciliar

B Tumor de Pancoast con Síndrome de Horner por compromiso del ganglio simpático estrellado

C Síndrome de Vena Cava Superior por compresión de la aurícula derecha

D Miopatía tiroidea con infiltración de la base de la lengua

E Neuralgia postherpética de ramas torácicas altas

Respuesta B. Tumor del surco superior que invade el plexo braquial inferior (dolor en el borde cubital del brazo) y la cadena simpática cervical/ganglio estrellado (Horner ipsilateral: ptosis, miosis, anhidrosis).

▶ VER CLASE 4.01.1.040 Hernias diafragmáticas traumáticas y congénitas

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.6 · Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino

QUÉ HAY QUE SABER

- Hernia diafragmática congénita (Bochdalek: posterolateral izquierda, la más frecuente): RN con distrés respiratorio, abdomen excavado, ruidos hidroaéreos en tórax y desplazamiento de ruidos cardíacos; asocia hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar. Morgagni: anterior, a menudo asintomática.
- Diagnóstico prenatal por ecografía (planificar parto en centro terciario); postnatal con Rx tórax (asas intestinales y SNG en el tórax).

- Manejo inicial en RN: intubación inmediata, evitar ventilación con mascarilla-bolsa (distiende el estómago), SNG para descompresión, cirugía diferida tras estabilización.
- Hernia diafragmática traumática: más frecuente izquierda tras trauma cerrado de alta energía o penetrante toracoabdominal; puede pasar inadvertida y manifestarse tardíamente como obstrucción o estrangulación.
- Sospechar en Rx con elevación del hemidiafragma, nivel hidroaéreo o SNG en tórax; confirmar con TAC. Seguimiento: derivar a cirugía (reparación quirúrgica).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 34 años con antecedente de accidente de tránsito con trauma toracoabdominal hace 3 años. Una radiografía de tórax por un cuadro respiratorio banal muestra asas intestinales en el tercio inferior del hemitórax izquierdo. Está asintomático desde el punto de vista digestivo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Observación y radiografía de control en 6 meses

B Cirugía de reparación electiva

C Cirugía de urgencia

D Inhibidor de la bomba de protones y control

E Endoscopía digestiva alta

Respuesta B. Hernia diafragmática traumática crónica descubierta como hallazgo. Aunque esté asintomático, no se observa: se repara de forma electiva para evitar obstrucción, incarceración o estrangulación. La cirugía de urgencia se reserva para la fase aguda o la hernia complicada.

▶ VER CLASE 4.01.1.041 Síndromes mediastínicos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.6 · Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino

QUÉ HAY QUE SABER

- Masas mediastínicas por compartimento: anterior (las 4 T: timoma, teratoma/tumor germinal, tiroides endotorácico, «terrible» linfoma), medio (adenopatías, quistes broncogénicos y pericárdicos), posterior (tumores neurogénicos).
- Síndrome de vena cava superior: edema en esclavina de cara, cuello y brazos, circulación colateral torácica, cefalea y disnea; causa principal cáncer pulmonar y linfoma.
- Otros síndromes por compresión: disfagia (esófago), estridor/tos (tráquea), disfonía (nervio recurrente), Horner (simpático). Timoma asociado a miastenia gravis.
- Estudio: Rx tórax (ensanchamiento mediastínico) y TAC de tórax con contraste; marcadores (β-hCG, alfafetoproteína) en masa anterior de hombre joven; biopsia antes de iniciar tratamiento.
- Manejo inicial del SVCS: cabecera elevada, oxígeno, evitar vías venosas en brazos; corticoides solo si linfoma confirmado o compromiso de vía aérea. Seguimiento: derivar a cirugía de tórax/oncología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En una radiografía de tórax de control se observa un ensanchamiento del mediastino anterior en un paciente de 40 años con diplopía y fatigabilidad muscular que mejora con el reposo. **¿Cuál es el examen a solicitar y la sospecha?**

A Ecografía torácica; quiste pericárdico

B TAC de tórax con contraste; timoma asociado a miastenia gravis

C Resonancia de columna; tumor neurogénico

D PET-CT; linfoma de Hodgkin

E Cintigrafía tiroidea; bocio endotorácico

Respuesta B. Masa en el mediastino anterior + miastenia gravis (diplopía y debilidad fluctuante que mejora con el reposo) orientan a timoma. El examen de elección para cualquier masa mediastínica es el TAC de tórax con contraste. Timoma con miastenia: timectomía, que puede mejorar la miastenia.

▶ VER CLASE 4.01.1.042 Mesotelioma pleural

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 3.5 · Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumor maligno de la pleura fuertemente asociado a exposición a asbesto (latencia de 20-40 años): trabajadores de construcción, astilleros, frenos, fibrocemento.
- Clínica: disnea progresiva, dolor torácico sordo no pleurítico, baja de peso; derrame pleural unilateral recurrente, frecuentemente hemorrágico.
- Imagen: engrosamiento pleural nodular o circunferencial, placas pleurales calcificadas (marcador de exposición), retracción del hemitórax en TAC.
- Diagnóstico: citología del líquido suele ser insuficiente; requiere biopsia pleural por toracoscopía (VATS) con inmunohistoquímica.
- Manejo inicial: toracocentesis evacuadora para alivio sintomático, analgesia. Seguimiento: derivar a broncopulmonar/oncología (quimioterapia, inmunoterapia, pleurodesis). Es enfermedad profesional (Ley 16.744).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años, que trabajó 25 años instalando aislantes de asbesto, consulta por disnea progresiva, dolor torácico sordo persistente y baja de peso de 3 meses. La radiografía muestra derrame pleural derecho y la TAC revela engrosamiento pleural nodular y circunferencial. El líquido pleural es un exudado hemático con citología negativa. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A Biopsia pleural por toracoscopía

B Repetir la citología del líquido pleural

C Fibrobroncoscopía

D Marcadores tumorales en sangre

E Adenosina deaminasa en líquido pleural

Respuesta A. Exposición a asbesto con derrame unilateral y engrosamiento pleural nodular y circunferencial sugiere mesotelioma pleural maligno. La citología tiene baja sensibilidad para este tumor; el diagnóstico requiere histología con inmunohistoquímica, idealmente por biopsia pleural toracoscópica. La ADA orienta a tuberculosis pleural, que no explica el engrosamiento nodular.

▶ VER CLASE 4.01.1.043 Síndrome de ocupación pleural

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 3.1 · Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light

QUÉ HAY QUE SABER

- Derrame pleural: disnea, dolor pleurítico, matidez, abolición del murmullo vesicular y de vibraciones vocales. Rx: borramiento del ángulo costofrénico (≥200 ml en PA), curva de Damoiseau; ecografía detecta volúmenes pequeños.
- Toracocentesis diagnóstica en todo derrame nuevo sin causa evidente (salvo insuficiencia cardíaca bilateral típica): criterios de Light para exudado (proteína pleura/plasma >0,5, LDH pleura/plasma >0,6 o LDH >2/3 del límite normal).
- Trasudado: insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico. Exudado: paraneumónico, TBC (ADA >40-45, linfocitos), cáncer (citología), TEP.
- Derrame paraneumónico complicado/empiema: pH <7,2, glucosa <60 mg/dl, LDH >1000, Gram/cultivo positivo o pus → drenaje pleural con tubo además de antibióticos.
- Neumotórax es la otra ocupación pleural: a tensión es emergencia (descompresión con aguja en 2° espacio intercostal línea medioclavicular o 4°-5° línea axilar media). Seguimiento: derivar a broncopulmonar/cirugía de tórax.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 143

Un paciente de 19 años consulta por dolor torácico derecho, de 24 horas de evolución, que aumenta con la inspiración. Al examen físico, se aprecia disminución del murmullo pulmonar en el lado derecho. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación: [radiografía: neumotórax derecho extenso]. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Control radiológico en 24 horas

B Solicitar TAC de tórax

C Realizar cirugía abierta

D Drenaje con tubo pleural

E Videotoracoscopía

Respuesta D. La radiografía mostraba un neumotórax derecho grande. Neumotórax primario grande: se evacúa el aire con aspiración o tubo pleural. La videotoracoscopía no se indica en un primer episodio salvo fuga persistente u otra indicación.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 64 años, fumador, con baja de peso, disnea progresiva y dolor sordo en el hemitórax izquierdo. Rx: derrame pleural izquierdo moderado. Toracocentesis: líquido amarillo cetrino, proteínas 4,2 g/dL (plasma 6,8 g/dL), LDH 380 U/L (plasma 240 U/L; límite superior normal 250 U/L). **¿Cuál es la clasificación del líquido y la conducta más adecuada?**

A Trasudado; iniciar furosemida

B Exudado; citología y biopsia pleural

C Trasudado; ecocardiograma

D Exudado; instalar tubo pleural de inmediato

E No clasificable; repetir la punción en 1 semana

Respuesta B. Proteínas LP/S = 4,2/6,8 = 0,62 (> 0,5); LDH LP/S = 380/240 = 1,58 (> 0,6); LDH LP 380 > 2/3 de 250. Es un exudado. En un fumador con síndrome consuntivo, se estudia con citología y biopsia pleural para descartar neoplasia.

▶ VER CLASE 4.01.1.044 Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.19 · Patología Vascular Periférica: Aneurismas, Várices e Insuficiencia Venosa & Úlceras de las Piernas

QUÉ HAY QUE SABER

- Aneurisma de aorta torácica: asociado a aterosclerosis, HTA, Marfan, Ehlers-Danlos, válvula aórtica bicúspide, sífilis; la mayoría asintomático (hallazgo de mediastino ensanchado en Rx).

- Síntomas por compresión (disfonía, disfagia, tos, SVCS) o dolor torácico/dorsal; dolor súbito intenso sugiere disección o rotura (emergencia). Indicación quirúrgica en general ≥5,5 cm (menor en Marfan).
- Aneurisma poplíteo: el periférico más frecuente, masa pulsátil en hueco poplíteo; frecuentemente bilateral (50%) y asociado a aneurisma aórtico (buscarlo). Complicación típica: trombosis/embolia con isquemia aguda, no rotura.
- Aneurisma femoral: masa pulsátil inguinal; diferenciar de pseudoaneurisma post punción (cateterismo).
- Estudio: ecografía Doppler (periféricos), angioTAC (torácico). Manejo inicial: control de PA, cese de tabaco, estatinas. Seguimiento: derivar a cirugía vascular.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 70 años, hipertenso y exfumador, consulta por una masa pulsátil asintomática en el hueco poplíteo derecho. La ecografía Doppler confirma un aneurisma de la arteria poplítea de 3 cm, con trombo mural. **¿Cuál es la complicación más frecuente de esta patología?**

A Trombosis o embolia distal con isquemia aguda de la pierna

B Rotura con hemorragia masiva

C Compresión del nervio ciático

D Fístula arteriovenosa

E Insuficiencia cardíaca de alto débito

Respuesta A. A diferencia del aneurisma de aorta abdominal, cuya complicación temida es la rotura, el aneurisma poplíteo se complica principalmente con trombosis o embolización distal, con isquemia aguda y riesgo de amputación. Por eso se reparan los sintomáticos o mayores de 2 cm, y se busca un aneurisma contralateral y aórtico asociado.

▶ VER CLASE 4.01.1.045 Enfermedad renovascular

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.3 · Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- Estenosis de arteria renal: aterosclerótica (>90%, adulto mayor con aterosclerosis difusa, fumador) o displasia fibromuscular (mujer joven, aspecto en «cuentas de rosario»).
- Sospechar ante: HTA de inicio <30 o >55 años, HTA resistente o maligna, empeoramiento brusco de HTA controlada, edema pulmonar flash, soplo abdominal, asimetría renal >1,5 cm.
- Caída de la VFG >30% al iniciar IECA o ARA II es clave para sospechar estenosis bilateral o de riñón único.
- Estudio: ecografía Doppler renal (screening), angioTAC o angio-RM; arteriografía es el gold standard.
- Manejo inicial: control de PA (IECA/ARA II con monitoreo de creatinina y potasio), estatinas, antiagregación, cese tabaco. Seguimiento: derivar a nefrología/cirugía vascular (angioplastía en displasia fibromuscular).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 22 años, sin antecedentes, consulta por cefalea pulsátil recurrente de 2 meses. Delgada, PA 175/105 mmHg en ambos brazos, FC 72 lpm. Soplo sistólico rudo en flanco derecho que se prolonga hacia la fosa lumbar. Creatinina 0,8 mg/dL, K 3,3 mEq/L, HCO_3 28 mEq/L. No usa anticonceptivos orales. **¿Cuál es el primer examen a solicitar?**

A Arteriografía renal selectiva

B Ecografía Doppler de arterias renales

C Monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas

D AngioTAC de arterias renales

E Metanefrinas urinarias

Respuesta B. HTA severa en mujer joven sin factores metabólicos, soplo en flanco y potasio limítrofe por hiperaldosteronismo secundario: HTA renovascular por displasia fibromuscular. El primer examen es el Doppler de arterias renales; la arteriografía es el estándar de oro y se usa para tratar (angioplastía con balón sin stent).

▶ VER CLASE 4.01.1.046 Insuficiencia cerebro vascular

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.2 · Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Enfermedad carotídea aterosclerótica: causa importante de ACV isquémico; se manifiesta como AIT (déficit focal transitorio, amaurosis fugax ipsilateral) o infarto. Soplo carotídeo es poco sensible.
- AIT es urgencia: riesgo alto de ACV en los primeros días (escala ABCD2 orienta). Estudiar con imagen cerebral y Doppler carotídeo precoz.
- Insuficiencia vertebrobasilar: vértigo, diplopía, disartria, ataxia, drop attacks; síndrome del robo de la subclavia (síntomas al ejercitar el brazo, diferencia de PA entre brazos >20 mmHg).
- Manejo inicial: antiagregación (AAS 100 mg; doble antiagregación corta en AIT de alto riesgo), estatina de alta intensidad, control de HTA, DM y tabaco. ACV isquémico es GES.
- Seguimiento: derivar a neurología/cirugía vascular para endarterectomía carotídea en estenosis sintomática ≥70% (beneficio también en 50-69%), idealmente en las 2 primeras semanas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 66 años, hipertenso, presenta un episodio de 30 minutos de debilidad de la mano derecha y dificultad para hablar, con recuperación completa. La TAC de cerebro es normal. La ecografía Doppler carotídea muestra una estenosis de 80% de la carótida interna izquierda. **Además del tratamiento médico óptimo, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Anticoagulación con heparina y luego warfarina

B Control con Doppler carotídeo en 6 meses

C Endarterectomía carotídea izquierda precoz, idealmente dentro de 2 semanas

D Endarterectomía carotídea derecha

E Trombólisis endovenosa

Respuesta C. Un AIT del territorio carotídeo izquierdo con estenosis sintomática ipsilateral de 70 a 99% tiene indicación de endarterectomía carotídea (o angioplastia con stent en casos seleccionados), idealmente dentro de 2 semanas, cuando el riesgo de recurrencia es mayor. La trombólisis no corresponde porque el déficit ya se resolvió.

▶ VER CLASE 4.01.1.047 Insuficiencia arterial crónica

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.3 · Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Enfermedad arterial periférica aterosclerótica: factores principales tabaco y diabetes; claudicación intermitente (dolor en pantorrilla al caminar que cede con reposo).
- Clasificación de Fontaine: I asintomático, II claudicación (IIa >200 m, IIb <200 m), III dolor de reposo, IV úlcera/gangrena. III-IV = isquemia crítica.
- Examen: pulsos disminuidos o ausentes, piel fría, atrofia, pérdida de vello, palidez a la elevación y rubor en declive. Diagnóstico específico: índice tobillo-brazo <0,9 (>1,3 sugiere calcificación arterial en diabéticos).
- Tratamiento inicial: dejar de fumar (lo más importante), ejercicio supervisado, AAS 100 mg o clopidogrel, estatina, control de DM y HTA; cilostazol 100 mg c/12 h para claudicación (contraindicado en insuficiencia cardíaca).
- Seguimiento: derivar a cirugía vascular claudicación invalidante, dolor de reposo, úlcera o gangrena (revascularización endovascular o bypass).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 146

Diabético fumador con dolor en pantorrillas al caminar 120 metros, ausencia de reflejos patelares, hipoestesia y pulsos pedios débiles. ¿Cuál es el examen de elección? **¿Cuál es el examen de elección?**

A Electromiografía y velocidad de conducción nerviosa

B AngioTAC de extremidades inferiores

C Arteriografía de extremidades inferiores

D Doppler venoso de extremidades inferiores

E Índice tobillo-brazo (ITB)

Respuesta E. Dolor de pantorrillas al caminar una distancia fija (claudicación intermitente) con pulsos débiles: enfermedad arterial periférica. El examen inicial es el índice tobillo-brazo; bajo 0,9 la confirma. Los signos de neuropatía son el distractor.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 146

Paciente diabético y fumador presenta dolor en las pantorrillas al caminar 120 metros. Al examen tiene reflejos patelares ausentes, hipoestesia y pulsos pedios débiles. **¿Cuál es el examen de elección?**

A Electromiografía y velocidad de conducción nerviosa

B AngioTAC de extremidades inferiores

C Arteriografía de extremidades inferiores

D Doppler venoso de extremidades inferiores

E Índice tobillo-brazo (ITB)

Respuesta E. La claudicación intermitente con pulsos pedios débiles sugiere enfermedad arterial periférica. El examen inicial de elección es el índice tobillo-brazo: un valor menor de 0,9 confirma el diagnóstico (en diabéticos puede estar falsamente elevado por calcificación arterial). La angioTAC o la arteriografía se reservan para planificar una revascularización.

▶ VER CLASE 4.01.1.048 Várices. Insuficiencia venosa crónica

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.19 · Patología Vascular Periférica: Aneurismas, Várices e Insuficiencia Venosa & Úlceras de las Piernas

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia venosa crónica: incompetencia valvular superficial (safena) o secuela de TVP; factores: edad, sexo femenino, embarazo, bipedestación prolongada, obesidad, herencia.
- Clínica: pesadez, dolor y edema vespertino que mejora con elevación, várices, prurito; clasificación CEAP C0-C6 (telangiectasias, várices, edema, cambios de piel como hiperpigmentación/dermatitis ocre y lipodermatoesclerosis, úlcera cicatrizada y activa).
- Diagnóstico específico: clínico, confirmado con ecografía Doppler venoso (reflujo, permeabilidad del sistema profundo), especialmente antes de cirugía.

- Tratamiento inicial: elevación de extremidades, ejercicio, bajar de peso, evitar bipedestación prolongada y compresión elástica graduada (20-30 o 30-40 mmHg) si no hay isquemia arterial (ITB >0,8); flebotónicos de apoyo.
- Seguimiento completo en APS: control de síntomas y piel; derivar a cirugía vascular si várices sintomáticas refractarias, varicorragia, tromboflebitis recurrente o úlcera (escleroterapia, ablación endovenosa, safenectomía).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 26

Mujer de 45 años con várices bilaterales en extremidades inferiores, sin úlceras ni tromboflebitis. Sin otros antecedentes mórbidos. **¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A Anticoagulación oral

B Flebectomía inmediata

C Escleroterapia de urgencia

D Medidas conservadoras: dieta, ejercicio y medias compresivas

E Derivación vascular urgente

Respuesta D. En la insuficiencia venosa crónica no complicada, el manejo inicial es conservador: control de peso, ejercicio, elevación de piernas y medias de compresión graduada. La cirugía o los procedimientos ablativos se plantean en forma electiva si persisten síntomas o aparecen complicaciones; ninguno es urgente, y la anticoagulación no tiene indicación.

▶ VER CLASE 4.01.1.049 Trombosis venosa profunda y tromboflebitis

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Cardiología 5.5 · Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP)
Traumatología 12.3 · Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente

QUÉ HAY QUE SABER

- TVP: edema unilateral de extremidad, dolor, aumento de temperatura y diámetro (>3 cm de diferencia), dilatación venosa superficial; signo de Homans poco sensible. Factores de Virchow: estasia, daño endotelial, hipercoagulabilidad (cirugía, inmovilización, cáncer, ACO, embarazo).
- Diagnóstico específico: escala de Wells; probabilidad baja → dímero D (si negativo descarta); probabilidad alta o dímero positivo → ecografía Doppler venosa (no compresibilidad).
- Tratamiento inicial: anticoagulación inmediata con heparina de bajo peso molecular (enoxaparina 1 mg/kg c/12 h SC) o anticoagulante oral directo, con traslape a warfarina (INR 2-3) si se elige ésta; duración mínima 3 meses.
- Tromboflebitis superficial: cordón eritematoso doloroso en vena superficial; AINE, calor local y compresión; anticoagular si >5 cm de longitud o cercana (<3 cm) al cayado safeno-femoral.
- Banderas rojas: disnea o dolor torácico (TEP), flegmasia cerulea dolens. Seguimiento: derivar para estudio de trombofilia/cáncer en TVP no provocada; prevención con tromboprofilaxis en hospitalizados y postoperados.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 64 años, operado hace 12 días de una fractura de cadera, sin profilaxis antitrombótica desde el alta. Consulta por aumento de volumen y dolor de la pantorrilla izquierda de 2 días. Al examen, la pierna izquierda tiene 4 cm más de circunferencia que la derecha, edema con fóvea y dolor a la palpación del trayecto venoso. Sin disnea, saturación 97%. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar dímero D y, si es positivo, repetirlo en 1 semana

B Instalar un filtro de vena cava inferior como primera medida

C Indicar AINE y reposo con la pierna elevada

D Solicitar flebografía antes de cualquier tratamiento

E Ecografía doppler venosa de la extremidad e iniciar anticoagulación, por ejemplo con heparina de bajo peso molecular

Respuesta E. Con alta probabilidad clínica (cirugía traumatológica reciente, edema asimétrico, dolor en el trayecto venoso), el dímero D no aporta: se confirma con ecografía doppler y se anticoagula, iniciando sin esperar si hay demora y no hay contraindicación. El filtro de cava se reserva para quienes no pueden anticoagularse.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 48 años con várices en ambas piernas consulta por un cordón indurado, rojo, caliente y doloroso en la cara medial de la pierna derecha, bajo la rodilla, de 3 días de evolución, tras un golpe con el pedal de la bicicleta. Sin fiebre ni edema de la extremidad. La ecografía doppler muestra trombosis de un segmento de la vena safena mayor a 15 cm de la unión safenofemoral, con venas profundas permeables. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Antibióticos endovenosos por celulitis

B Anticoagulación oral con warfarina por 6 meses

C Calor local, AINE, compresión elástica y deambulación, con control clínico

D Reposo absoluto en cama con la pierna en alto por 2 semanas

E Instalar un filtro de vena cava inferior

Respuesta C. Una tromboflebitis superficial corta, alejada más de 3 cm de la unión safenofemoral y sin trombosis profunda, se trata con calor local, AINE, compresión y deambulación. Se anticoagula si el segmento mide 5 cm o más, está cerca del cayado o se asocia a TVP. El reposo absoluto favorece la progresión.

▶ VER CLASE 4.01.1.050 Ulceras de las piernas (venosas, varicosas, hipert. y específicas)

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.19 · Patología Vascular Periférica: Aneurismas, Várices e Insuficiencia Venosa & Úlceras de las Piernas

QUÉ HAY QUE SABER

- Úlcera venosa (~70%): región maleolar medial, bordes irregulares, poco dolorosa, fondo granulante, con edema, dermatitis ocre y lipodermatoesclerosis.
- Úlcera arterial: distal (dedos, talón, prominencias), bordes netos en «sacabocado», fondo pálido, muy dolorosa, pulsos ausentes. Úlcera hipertensiva de Martorell: cara lateral de pierna, muy dolorosa, en hipertenso con pulsos presentes.
- Úlcera neuropática (diabética): zonas de apoyo plantar, indolora, con callosidad. Específicas: pioderma gangrenoso (EII, AR), vasculitis, neoplásicas (Marjolin: úlcera crónica que se maligniza → biopsiar si no cicatriza o tiene bordes evertidos).
- Diagnóstico específico: palpación de pulsos e ITB en toda úlcera (≥0,9 normal; <0,8 contraindica compresión fuerte), Doppler venoso/arterial y biopsia si atípica.
- Tratamiento inicial: curación avanzada (aseo, desbridamiento, apósitos húmedos), tratar infección, compresión en venosa con ITB adecuado, elevación. Seguimiento: derivar a cirugía vascular/dermatología según causa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 61

Hombre de 58 años, con várices de gran tamaño en ambas piernas, consulta porque hace 2 semanas sufrió un pequeño trauma en la extremidad inferior izquierda y evolucionó con una lesión ulcerada que ha aumentado de tamaño hasta 1,5 cm, ubicada a 2 cm del maléolo interno. Al examen se aprecia oscurecimiento de la piel circundante, además de las várices. **¿Cuál es la etiología más probable de la lesión?**

A Infecciosa
B Isquémica
C Venosa
D Neuropática
E Por presión

Respuesta C. Una úlcera en la zona perimaleolar interna, en un paciente con várices e hiperpigmentación (dermatitis ocre), es típicamente venosa. Las úlceras isquémicas son distales (ortejos, talón), muy dolorosas y con pulsos ausentes; las neuropáticas aparecen en zonas de apoyo plantar.

▶ VER CLASE 4.01.1.051 Pie diabético

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.3 · Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Pie diabético: úlcera, infección o destrucción de tejidos del pie en diabético asociada a neuropatía y/o enfermedad arterial periférica; principal causa de amputación no traumática.
- Evaluación específica: sensibilidad con monofilamento 10 g y diapasón, pulsos pedios y tibiales posteriores, ITB, deformidades (Charcot), clasificación de Wagner (0 a 5) o Texas; Rx para osteomielitis (sonda que toca hueso = probe-to-bone).
- Infección leve: celulitis <2 cm sin compromiso sistémico → antibiótico oral (amoxicilina-ácido clavulánico o cefadroxilo, clindamicina si alergia). Moderada-grave (absceso, celulitis extensa, gangrena, sepsis) → hospitalizar, antibióticos IV y aseo quirúrgico.
- Tratamiento inicial de úlcera: descarga (no apoyar), curación avanzada, control glicémico, desbridamiento, evaluar perfusión.
- Prevención GES/PSCV: evaluación anual del pie con puntaje de riesgo, educación, calzado adecuado, revisión diaria. Seguimiento: derivar a cirugía vascular/equipo de pie diabético si isquemia, infección profunda o Wagner ≥3.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 64 años, DM2 de 16 años mal controlada, tabáquico. Úlcera plantar de 3 semanas, de 2,5 cm, sobre la cabeza del 1.er metatarsiano, con hiperqueratosis alrededor e indolora. Al explorar el fondo con un estilete estéril, choca con una superficie dura y rugosa. Pie tibio, pulsos pedio y tibial posterior presentes. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Curación avanzada ambulatoria y descarga; control en 1 semana
B Cefadroxilo oral por 10 días y curación en APS
C Hospitalizar: imagen, desbridamiento con biopsia ósea, descarga y antibióticos EV
D Amputación supracondílea de urgencia
E Derivar a cirugía vascular para bypass ambulatorio

Respuesta C. Mal perforante plantar neuropático (indoloro, hiperqueratosis, pulsos presentes) con estilete óseo positivo: osteomielitis, Wagner 3. Se hospitaliza para radiografía o resonancia, desbridamiento quirúrgico con biopsia ósea para cultivo, descarga absoluta y antibióticos parenterales prolongados.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 143

Un paciente de 65 años, diabético en tratamiento con esquema intensificado de insulina, presenta desde hace unas semanas úlcera en zona plantar derecha, asociado a secreción purulenta. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones y afebril, se aprecia úlcera bajo la articulación metatarsofalángica del primer ortejo derecho, con compromiso de piel, tejido subcutáneo y tendones, sin signos de compromiso óseo ni articular. La conducta más adecuada en este caso es:

A Antibióticos vía oral y curaciones ambulatorias

B Angiografía

C Amputación abierta

D Amputación cerrada

E Antibióticos endovenosos y debridación quirúrgica

Respuesta E. Es una úlcera plantar infectada, purulenta y profunda, con compromiso de tendones pero sin signos de osteomielitis ni de sepsis. Corresponde hospitalizar para antibióticos endovenosos de amplio espectro y debridación quirúrgica del tejido desvitalizado. Los antibióticos orales y las curaciones ambulatorias no bastan en una infección profunda, y la amputación se reserva para la osteomielitis extensa o la gangrena.

▶ VER CLASE 4.01.1.052 Escaras

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.22 · Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Úlcera por presión: lesión por presión mantenida sobre prominencias óseas (sacro, trocánteres, talones, isquion) en pacientes inmovilizados, desnutridos, incontinentes o con alteración de conciencia.
- Clasificación: grado I eritema que no blanquea con piel intacta; II pérdida parcial de dermis (flictena); III pérdida total de piel hasta tejido subcutáneo; IV exposición de músculo, tendón o hueso.
- Prevención (lo más importante): cambios de posición cada 2 horas, colchón antiescaras, piel limpia y seca, manejo de incontinencia, nutrición e hidratación adecuadas; escala de Braden para riesgo.
- Tratamiento: alivio de presión, aseo con suero fisiológico, desbridamiento del tejido necrótico, apósitos según exudado, tratar infección y optimizar nutrición (proteínas).
- Seguimiento completo: curaciones y control por médico general y enfermería; derivar a cirugía si grado IV, osteomielitis o necesidad de colgajo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 84 años, postrada tras un accidente cerebrovascular, con incontinencia urinaria y desnutrición, vive con su hija. En la visita domiciliaria se observa eritema que no blanquea a la presión en la zona sacra, con piel indemne. **¿Cuál es la medida más importante para evitar la progresión de la lesión?**

A Masaje enérgico de la zona enrojecida

B Curación con apósito y decúbito supino permanente

C Antibiótico tópico en la zona

D Flotador o rosca bajo el sacro

E Cambios de posición programados cada 2 horas y superficie que redistribuya la presión

Respuesta E. Eritema no blanqueable con piel intacta corresponde a una úlcera por presión categoría 1. La medida clave es aliviar la presión: cambios posturales programados, colchón antiescaras, manejo de la humedad y apoyo nutricional. El masaje de la zona y los flotadores o roscas están contraindicados porque aumentan el daño tisular.

▶ VER CLASE 4.01.1.053 Tumores benignos de partes blandas

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.8 · Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

QUÉ HAY QUE SABER

- Lipoma: tumor más frecuente de partes blandas; masa subcutánea blanda, móvil, indolora, de crecimiento lento. Resección si sintomático, estético o >5 cm (descartar liposarcoma).
- Quiste epidérmico (sebáceo): nódulo dérmico con punto central (poro), contenido queratínico maloliente; se puede infectar (drenaje en agudo, extirpación completa con cápsula en frío).
- Otros: quiste triquilemal (cuero cabelludo), ganglión (dorso de muñeca, sobre vaina tendínea), neurofibroma, dermatofibroma, hemangioma.
- Diagnóstico específico clínico; ecografía si duda sobre naturaleza, profundidad o tamaño.
- Signos de alarma para derivar: >5 cm, profundo (bajo la fascia), crecimiento rápido, dolor o fijación → sospecha de sarcoma. Seguimiento: derivar a cirugía para extirpación según indicación.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años consulta por un aumento de volumen en la espalda que ha crecido muy lentamente en 3 años. Al examen se palpa una masa de 4 cm, blanda, móvil, indolora, no adherida a la piel ni a planos profundos, sin punto central ni signos inflamatorios. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Quiste epidérmico
B Liposarcoma
C Lipoma
D Absceso subcutáneo
E Linfadenopatía

Respuesta C. Masa subcutánea blanda, móvil, indolora, de crecimiento lento y no adherida a la piel es un lipoma, el tumor benigno de partes blandas más frecuente. El quiste epidérmico está adherido a la piel y suele tener un poro central. Masas mayores de 5 cm, profundas, duras o de crecimiento rápido obligan a descartar sarcoma.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 79

Joven con aumento de volumen blando no adherido en muslo derecho (?era en la espalda), estudio inicial:

A Ecografía de piel y partes blandas (REPETIDA DEL 2023)
B Psoriasis
C Dermatitis atópica
D Dermatitis de contacto
E Liquen plano

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Ecografía de piel y partes blandas (REPETIDA DEL 2023)).

▶ VER CLASE 4.01.1.054 Tumores malignos de partes blandas

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.8 · Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

QUÉ HAY QUE SABER

- Sarcomas de partes blandas: raros, origen mesenquimal; más frecuentes en extremidades (muslo) y retroperitoneo. Tipos: liposarcoma, leiomiosarcoma, sarcoma pleomórfico indiferenciado; rabdomiosarcoma en niños.
- Sospechar ante masa >5 cm, profunda a la fascia, de crecimiento progresivo o recurrente tras extirpación. Muchas veces indolora.
- Estudio: RM de la zona (de elección en extremidades), TAC de tórax (metástasis pulmonares, diseminación hematógena).
- No hacer biopsia excisional ni «enucleación» en el APS: la biopsia (core) la planifica el equipo que hará la cirugía definitiva para no contaminar planos.
- Seguimiento: derivar a centro especializado (cirugía oncológica/traumatología oncológica): resección amplia con márgenes y radioterapia según grado.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 101

Paciente de 18 años consulta porque desde hace un año presenta aumento de volumen progresivo en la cara anterior del muslo derecho, que recientemente se ha vuelto doloroso. Al examen se palpa una masa de 10 centímetros de diámetro, de consistencia dura, no pétrea, sin afectación de la piel. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar resección y biopsia
B Observar evolución
C Solicitar ecografía de partes blandas
D Solicitar radiografía de fémur
E Realizar punción y drenaje

Respuesta C. Masa de más de 5 centímetros, de un año de evolución y crecimiento reciente: bandera roja de sarcoma de partes blandas. Antes de resecar, se estudia con imagen; si no hay resonancia disponible de entrada, la ecografía distingue lo benigno de lo sospechoso y guía el paso siguiente.

▶ VER CLASE 4.01.1.055 Abscesos, forúnculos, panadizos, flegmones

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.8 · Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas
Infectología 5.1 · Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Forúnculo: infección del folículo piloso (S. aureus) con nódulo doloroso y pus; ántrax: varios forúnculos confluentes. Absceso: colección de pus con fluctuación. Flegmón: infección difusa del tejido celular subcutáneo sin colección.
- Panadizo: infección del pulpejo (felón) o periungueal (paroniquia). Paroniquia aguda: S. aureus; crónica: Candida en manos húmedas.
- Diagnóstico clínico; ecografía si duda de colección. Banderas rojas: crepitación, dolor desproporcionado, necrosis o toxicidad (fascitis necrotizante → pabellón urgente), compromiso de vaina tendínea (signos de Kanavel).
- Tratamiento completo: drenaje quirúrgico de toda colección (incisión, aseo, mecha); antibiótico si celulitis asociada, compromiso sistémico, inmunosupresión o zona facial: cefadroxilo 500 mg-1 g c/12 h o flucloxacilina 500 mg c/6-8 h por 7 días; clindamicina si alergia o SAMR comunitario.
- Seguimiento completo: curaciones cada 24-48 h; forunculosis recurrente: descolonización (mupirocina nasal, clorhexidina), estudiar diabetes.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 28

Un paciente alcohólico, de 50 años, en situación de calle, consulta por dolor en el antebrazo derecho, muy intenso. Al examen físico se aprecia una lesión grande en el antebrazo derecho, con áreas violáceas, que crepita a la palpación. Su frecuencia cardiaca es de 108x`, con PA: 90/60 mmHg y su hemograma muestra leucocitosis de 17.000. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Loxocelismo cutáneo
B Celulitis
C Úlcera por presión
D Fascitis necrosante
E Miositis necrosante

Respuesta D. Dolor muy intenso, áreas violáceas y crepitación (gas tisular), con taquicardia, hipotensión y leucocitosis: fascitis necrotizante.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 32 años, sin enfermedades crónicas, consulta por 4 días de dolor y aumento de volumen en el glúteo derecho. Al examen hay una masa de 4 cm, eritematosa, caliente y fluctuante, con mínimo eritema perilesional. Está afebril y en buen estado general. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Antibiótico oral por 10 días y control
B Hospitalizar para antibióticos endovenosos
C Calor local y observar si drena espontáneamente
D Solicitar ecografía de partes blandas antes de cualquier tratamiento
E Drenaje quirúrgico con anestesia local, aseo de la cavidad y curaciones

Respuesta E. Un absceso fluctuante se trata drenándolo: incisión con anestesia local, vaciamiento y aseo de la cavidad, y curaciones. Los antibióticos por sí solos no penetran la colección y se reservan para celulitis extensa, compromiso sistémico o inmunosupresión.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 32 años, sin comorbilidades, con 5 días de un nódulo doloroso en la axila derecha. Al examen hay una lesión de 3 cm, eritematosa, caliente y fluctuante, con mínima celulitis alrededor. Está afebril. **¿Cuál es el tratamiento principal?**

A Compresas tibias y control en 1 semana
B Cefadroxilo oral como única medida
C Incisión y drenaje del absceso
D Hospitalizar para vancomicina endovenosa
E Punción con aguja fina para cultivo y observar

Respuesta C. Una colección fluctuante es un absceso y su tratamiento fundamental es la incisión y el drenaje. En un paciente sano, afebril y sin celulitis extensa, el antibiótico no es necesario; se agrega si hay compromiso sistémico, celulitis importante, inmunosupresión o una ubicación de riesgo. El antibiótico solo no resuelve una colección.

▶ VER CLASE 4.01.1.056 **Secuelas de quemaduras** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.13 · Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Secuelas de quemaduras: cicatrices hipertróficas (limitadas a la herida, mejoran con el tiempo), queloides (exceden el borde), contracturas y bridas que limitan movilidad, alteraciones pigmentarias.
- Mayor riesgo en quemaduras profundas (AB y B o 2° profunda/3° grado), cicatrización >21 días, zonas de flexión (cuello, axila, codo, manos) y niños.
- Úlcera de Marjolin: carcinoma escamoso sobre cicatriz de quemadura crónica; biopsiar toda úlcera persistente en cicatriz antigua.
- Prevención y manejo inicial: prendas compresivas por 6-12 meses, láminas de silicona, hidratación, protección solar, kinesioterapia y férulas para evitar contracturas.
- Seguimiento: derivar a cirugía plástica/unidad de quemados para manejo de bridas (Z-plastias, injertos, colgajos), rehabilitación y apoyo psicológico. Gran quemado es GES.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 161

Hombre de 52 años, con una gran cicatriz de una quemadura antigua en el muslo derecho, que cicatrizó por segunda intención, refiere que desde hace 2 años presenta una úlcera en relación con la cicatriz. Al examen se observa una úlcera de 2 cm en medio de la cicatriz. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tratamiento con nitrógeno líquido

B Aseo quirúrgico

C Resección amplia

D Biopsia incisional

E Curaciones con povidona y suero fisiológico

Respuesta D. Una úlcera crónica que no cicatriza sobre una cicatriz de quemadura antigua hace sospechar una úlcera de Marjolin, habitualmente un carcinoma espinocelular. Primero debe confirmarse con biopsia incisional de bordes y lecho; con el diagnóstico se planifica la resección amplia. Resecar sin histología o solo hacer curaciones retrasa el tratamiento oncológico.

▶ VER CLASE 4.01.1.057 Cicatrices viciosas

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.18 · Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

QUÉ HAY QUE SABER

- Cicatriz hipertrófica: elevada, eritematosa, confinada al borde de la herida, aparece en semanas y tiende a mejorar en 6-12 meses; frecuente en zonas de tensión y flexión.
- Queloide: sobrepasa los márgenes de la herida original, persiste o crece, no regresa espontáneamente; predisposición genética, piel oscura, zonas como lóbulo auricular, esternón, hombros.
- Cicatrices viciosas también incluyen retráctiles (bridas que limitan movimiento), deprimidas y ensanchadas; factores: infección, tensión, mala técnica de sutura, cierre por segunda intención.
- Manejo inicial: compresión, silicona en gel o lámina, masaje, fotoprotección; infiltración con corticoide (triamcinolona) en queloides y cicatrices hipertróficas refractarias.
- Seguimiento: derivar a cirugía plástica/dermatología queloides, bridas funcionales o cicatrices estéticamente relevantes (resección + terapia adyuvante; los queloides recidivan frecuentemente si solo se extirpan).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 20 años consulta por una lesión firme, brillante y pruriginosa en el lóbulo de la oreja izquierda, que apareció 4 meses después de una perforación para aros y ha seguido creciendo, sobrepasando los límites de la herida original. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A Resección quirúrgica simple aislada

B Infiltración intralesional de corticoides

C Crema antibiótica

D Observación, porque regresa espontáneamente

E Radioterapia exclusiva

Respuesta B. Una cicatriz que crece más allá de los bordes de la herida original y no regresa es un queloide; la cicatriz hipertrófica se limita a la herida y tiende a mejorar. El tratamiento inicial es la infiltración intralesional de corticoides, asociada a presoterapia o láminas de silicona. La resección aislada tiene una recurrencia muy alta.

▶ VER CLASE 4.01.1.058 Condilomas

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.5 · Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH

QUÉ HAY QUE SABER

- Condilomas acuminados: infección por VPH de bajo riesgo (6 y 11); pápulas exofíticas, en coliflor, del color de la piel, en genitales, periné y región perianal; transmisión sexual.
- Diagnóstico clínico; biopsia si lesión atípica, pigmentada, ulcerada, indurada, refractaria o en inmunosuprimido. Perianales: realizar anoscopía para lesiones intraanales.
- Asociados a otras ITS: ofrecer VIH, sífilis (diferenciar de condiloma plano sifilítico), hepatitis B; examinar y tratar pareja. En mujeres, PAP según programa.
- Tratamiento inicial: crioterapia, podofilotoxina 0,5% (autoaplicada; contraindicada en embarazo), imiquimod 5% o ácido tricloroacético 80-90% (seguro en embarazo).
- Seguimiento: derivar a dermatología/coloproctología/ginecología si extensos, intraanales, refractarios o en inmunosuprimidos. Prevención: vacuna VPH en el PNI escolar y preservativo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 24 años, cursando un embarazo de 20 semanas, consulta por múltiples verrugas exofíticas pequeñas e indoloras en la vulva. El resto del examen es normal. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Podofilina tópica

B Crioterapia o ácido tricloroacético

C Imiquimod tópico

D Cesárea programada por los condilomas

E Aciclovir oral

Respuesta B. Los condilomas acuminados, por VPH 6 y 11, se tratan en la embarazada con métodos locales físicos o químicos: crioterapia, ácido tricloroacético o resección. La podofilina y la podofilotoxina están contraindicadas por toxicidad fetal, y el imiquimod no se recomienda. La cesárea solo se indica si las lesiones obstruyen el canal o hay riesgo de sangrado.

▶ VER CLASE 4.01.1.059 Onicocriptosis

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.21 · Procedimientos de Cirugía Menor: Punción Venosa, Manejo de Drenajes, Onicocriptosis & Onicectomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Onicocriptosis (uña encarnada): borde lateral de la uña, casi siempre del ortejo mayor, incrustado en el rodete periungueal; factores: corte curvo o muy corto, calzado estrecho, hiperhidrosis.
- Estadios: I inflamación (eritema, edema, dolor), II infección con supuración, III tejido de granulación hipertrófico y cronicidad.
- Tratamiento conservador en estadio I: baños de agua tibia, corte recto de la uña, levantar el borde con algodón o mecha, calzado amplio; antibiótico (cefadroxilo) solo si celulitis.
- Tratamiento completo en estadio II-III o recurrente: onicectomía parcial del borde afectado con matricectomía (química con fenol o quirúrgica) bajo anestesia troncular del ortejo.
- Seguimiento completo: curaciones diarias por 1-2 semanas, educación de corte recto; precaución en diabéticos y enfermedad arterial (riesgo de mala cicatrización): evaluar pulsos antes de operar.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Adolescente de 16 años consulta por dolor en el borde lateral del ortejo mayor derecho de 1 semana, con eritema leve y edema del pliegue ungueal, sin secreción purulenta ni tejido de granulación. Refiere que se corta las uñas en forma curva y usa zapatillas estrechas. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Onicectomía total

B Onicectomía parcial con matricectomía

C Antibiótico oral por 14 días

D Manejo conservador: baños tibios, levantar el borde ungueal con algodón, calzado holgado y corte recto de la uña

E Antifúngico tópico

Respuesta D. La onicocriptosis leve (dolor, eritema y edema, sin pus ni granuloma) se maneja en forma conservadora: higiene, baños tibios, elevar el borde con algodón, calzado amplio y cortar la uña recta. La onicectomía parcial con matricectomía se reserva para casos moderados a severos o recurrentes.

▶ VER CLASE 4.01.1.060 Obesidad mórbida

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.20 · Obesidad Mórbida y Cirugía Bariátrica: Indicaciones, Técnicas y Complicaciones

QUÉ HAY QUE SABER

- Obesidad mórbida: IMC ≥40 kg/m² o ≥35 con comorbilidades (DM2, HTA, apnea del sueño, dislipidemia, artrosis, hígado graso). Chile tiene alta prevalencia de obesidad.
- Evaluar causas secundarias (hipotiroidismo, Cushing, fármacos) y comorbilidades: glicemia/HbA1c, perfil lipídico, pruebas hepáticas, TSH, PA, tamizaje de apnea (STOP-BANG).
- Manejo inicial: cambios de estilo de vida (dieta hipocalórica, actividad física), terapia conductual y fármacos (liraglutida/semaglutida, orlistat) como coadyuvantes.
- Cirugía bariátrica indicada en IMC ≥40 o ≥35 con comorbilidad tras fracaso de tratamiento médico, con evaluación multidisciplinaria (manga gástrica, bypass gástrico en Y de Roux).
- Seguimiento: derivar a equipo de cirugía bariátrica/nutrición; postoperatorio requiere suplementación de por vida (hierro, B12, calcio, vitamina D) y control de déficit nutricional.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 75

Mujer de 35 años, con antecedente de bypass gástrico hace 1 año, presenta crisis de mareos, palpitaciones, malestar general y diarrea, que aparecen después de comer. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hipoglicemias reactivas
B Síndrome de dumping
C Hernia del espacio de Petersen
D Estenosis de la anastomosis
E Déficit de vitamina B12

Respuesta B. Síntomas vasomotores (mareo, palpitaciones) y digestivos (diarrea) poco después de comer, tras un bypass gástrico, son típicos del síndrome de dumping precoz, por llegada rápida de contenido hiperosmolar al intestino. Se maneja con comidas pequeñas y frecuentes, evitando azúcares simples. La hipoglicemia reactiva es más tardía y no explica la diarrea.

Situaciones clínicas de urgencia

31 códigos

▶ VER CLASE 4.01.2.001 **Esofagitis cáustica** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.4 · Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico

QUÉ HAY QUE SABER

- Ingesta de cáusticos: álcalis (soda cáustica, destapadores; necrosis por licuefacción, más daño esofágico) y ácidos (necrosis por coagulación, más daño gástrico). En niños accidental; en adultos frecuentemente intento suicida.
- Clínica: odinofagia, disfagia, sialorrea, dolor retroesternal, lesiones orales (su ausencia no descarta daño esofágico); estridor o disfonía indican compromiso de vía aérea; dolor intenso, enfisema o peritonismo sugieren perforación.
- Diagnóstico específico: endoscopía alta precoz (idealmente 12-24 h, evitar entre día 5 y 15) para clasificar el daño (Zargar); Rx/TAC de tórax y abdomen si sospecha de perforación.
- Tratamiento inicial: ABC, régimen cero, hidratación IV, IBP, analgesia. NO inducir vómito, NO neutralizar, NO lavado gástrico ni carbón activado, NO SNG a ciegas.
- Seguimiento: derivar a centro con endoscopía y cirugía; complicaciones: estenosis esofágica (semanas), perforación y mayor riesgo de cáncer escamoso a largo plazo. Evaluación por psiquiatría si fue intencional.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 24 años llega a urgencias 2 horas después de ingerir, con intención suicida, un vaso de destapador de cañerías a base de soda cáustica. Presenta sialorrea, odinofagia y dolor retroesternal. PA 120/75 mmHg, FC 104 por minuto, sin enfisema subcutáneo ni signos peritoneales. Radiografía de tórax y abdomen sin aire libre. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Inducir el vómito y administrar carbón activado
B Neutralizar con vinagre diluido por sonda nasogástrica
C Esofagectomía de urgencia
D Endoscopía digestiva alta diferida a las 3 semanas
E Régimen cero, hidratación endovenosa, analgesia y endoscopía digestiva alta en las primeras 12 a 24 horas

Respuesta E. Sin signos de perforación, se estabiliza con régimen cero y se hace endoscopía precoz (12–24 h, evitando el período de mayor fragilidad entre el día 3 y la semana 3) para graduar la lesión y definir el manejo. No se induce vómito, no se neutraliza ni se usa carbón. Requiere además evaluación psiquiátrica.

▶ VER CLASE 4.01.2.002 **Abdomen agudo** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.5 · Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)

QUÉ HAY QUE SABER

- Abdomen agudo: dolor abdominal de inicio reciente (<7 días) que requiere diagnóstico y eventual tratamiento quirúrgico urgente. Causas: inflamatorias (apendicitis, colecistitis, diverticulitis), obstructivas, perforativas, vasculares, hemorrágicas.
- Anamnesis: inicio, localización y migración, irradiación, vómitos, fiebre, tránsito; en mujer en edad fértil siempre β-hCG (embarazo ectópico). Examen: signos peritoneales (Blumberg, rigidez), Murphy, Rovsing, hernias, tacto rectal.
- Exámenes: hemograma, PCR, lipasa, pruebas hepáticas, orina completa, β-hCG; imágenes: ecografía (biliar, ginecológica, niños) o TAC de abdomen y pelvis; Rx de tórax de pie para neumoperitoneo.
- Tratamiento inicial: régimen cero, hidratación IV, analgesia (no enmascara el diagnóstico; opioide si es intenso), SNG si vómitos u obstrucción, antibióticos si sospecha de infección intraabdominal.
- Banderas rojas: shock, peritonitis difusa, dolor desproporcionado al examen (isquemia mesentérica), adulto mayor o inmunosuprimido con poca semiología. Seguimiento: derivar a cirugía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 24 años consulta por 8 horas de dolor en el hipogastrio y la fosa ilíaca derecha. Afebril, presión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 92. Tiene dolor a la palpación profunda de la fosa ilíaca derecha, sin signos peritoneales. Su última menstruación fue hace 7 semanas y no usa anticoncepción. **¿Cuál es el primer examen que se debe solicitar?**

A TAC de abdomen y pelvis con contraste

B Amilasa y lipasa

C Radiografía simple de abdomen

D Subunidad beta de gonadotrofina coriónica

E Colonoscopía

Respuesta D. En toda mujer en edad fértil con abdomen agudo, lo primero es descartar embarazo con subunidad beta. Con atraso menstrual, un embarazo ectópico debe descartarse antes que cualquier otra causa, y el resultado además condiciona el uso de radiación como la TAC.

▶ VER CLASE 4.01.2.003 Peritonitis

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.5 · Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)
Gastroenterología 1.4 · Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico

QUÉ HAY QUE SABER

- Peritonitis secundaria (la más frecuente): por perforación de víscera hueca o filtración (úlcera perforada, apendicitis, diverticulitis); polimicrobiana. Primaria (PBE): cirrótico con ascitis, monomicrobiana.
- Clínica: dolor abdominal difuso intenso, abdomen en tabla, Blumberg positivo, inmovilidad, fiebre, taquicardia, íleo; puede evolucionar a shock séptico.
- Diagnóstico específico: Rx de tórax de pie (neumoperitoneo) o TAC de abdomen; laboratorio con leucocitosis y PCR elevada, lactato. PBE: paracentesis con PMN ≥250/mm³.
- Tratamiento inicial: reanimación con cristaloides, antibióticos IV de amplio espectro precoces (ceftriaxona + metronidazol; piperacilina-tazobactam si grave), régimen cero, SNG, analgesia, Foley para diuresis.
- Seguimiento: derivar a cirugía urgente para control del foco (laparotomía/laparoscopía, aseo peritoneal). PBE no es quirúrgica: cefotaxima/ceftriaxona + albúmina.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 169

Paciente de 43 años, multípara, con dolor abdominal difuso, intenso y vómitos, con marcado meteorismo. Frecuencia cardíaca de 110 y presión arterial de 100/60. Al examen abdominal se observa cicatriz de cesárea, con abdomen muy doloroso a la palpación, distensión de la pared, pérdida de la matidez hepática a la percusión y abolición de los ruidos hidroaéreos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Obstrucción intestinal

B Pancreatitis aguda

C Perforación intestinal

D Megacolon

E Embolia mesentérica

Respuesta C. La pérdida de la matidez hepática indica neumoperitoneo, propio de una perforación. Sumado a la abolición de los ruidos hidroaéreos y el dolor intenso y difuso, el cuadro es de una peritonitis secundaria a perforación intestinal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 162

Paciente de 43 años con dolor epigástrico urente de un mes de evolución. Hace 24 horas deja de eliminar gases y el dolor se vuelve difuso y persistente, con distensión abdominal. Frecuencia cardíaca de 110 y presión arterial de 110/70. El abdomen está doloroso y distendido, con pérdida de la matidez hepática y ruidos hidroaéreos abolidos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Obstrucción intestinal

B Pancreatitis aguda

C Perforación de úlcera péptica

D Plastrón vesicular

E Cáncer de vesícula

Respuesta C. El mes de epigastralgia urente que mejoraba con la comida marca una úlcera activa de fondo. El cambio brusco a dolor difuso, íleo y pérdida de la matidez hepática es la perforación de esa misma úlcera hacia el peritoneo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 162

Un paciente de 43 años presenta dolor epigástrico urente, de un mes de evolución. Hace 24 horas deja de eliminar gases y el dolor se vuelve difuso y persistente, agregándose distensión abdominal. Al examen tiene frecuencia cardíaca de 110 por minuto, presión arterial de 110/70, abdomen doloroso y distendido, con pérdida de la matidez hepática y ruidos hidroaéreos abolidos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Obstrucción intestinal

B Pancreatitis aguda

C Perforación de úlcera péptica

D Plastrón vesicular

E Cáncer de vesícula

Respuesta C. Toda la clínica es de úlcera perforada: epigastralgia urente previa (síndrome ulceroso), y luego dolor intenso y difuso con íleo paralítico por la peritonitis (distensión, ruidos hidroaéreos abolidos) más el signo de neumoperitoneo, la pérdida de la matidez hepática, porque el aire libre se interpone entre el hígado y la pared.

▶ VER CLASE 4.01.2.004 Hemorragia digestiva alta

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 5.3 · Hemorragia Digestiva Alta y Baja

QUÉ HAY QUE SABER

- HDA: sangrado proximal al ángulo de Treitz; hematemesis (sangre roja o en «concho de café») y/o melena. Causas: úlcera péptica (más frecuente), várices esofágicas (cirrótico), Mallory-Weiss, esofagitis, cáncer.
- Evaluar gravedad: PA, FC, índice de shock, perfusión; hemoglobina inicial puede ser normal. Escala de Glasgow-Blatchford para decidir manejo ambulatorio vs hospitalización.
- Tratamiento inicial: 2 vías venosas gruesas, cristaloides, transfusión con Hb <7 g/dl (<8-9 en coronarios), corregir coagulación, régimen cero; IBP en bolo IV (omeprazol 80 mg) y luego infusión o 40 mg c/12 h.
- Sospecha de várices: octreótido (o terlipresina), ceftriaxona profiláctica 1 g/día, transfusión restrictiva. Balón de Sengstaken como puente si sangrado masivo incontrolable.
- Seguimiento: derivar para endoscopía alta en <24 h (antes si inestable): diagnóstico y terapia hemostática; erradicar H. pylori y suspender AINE en úlcera.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años, usuario de ibuprofeno por lumbago, consulta por hematemesis y melena. Ingresa con FC 110 lpm y PA 95/60 mmHg; se reanima con cristaloides y se inicia omeprazol endovenoso. La endoscopía a las 12 horas muestra una úlcera duodenal de 1,5 cm con un vaso visible no sangrante. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener solo omeprazol oral y dar de alta

B Cirugía de urgencia con vagotomía y piloroplastía

C Terapia endoscópica combinada (adrenalina más método térmico o clips) y omeprazol endovenoso

D Embolización arterial como primera opción

E Repetir la endoscopía en 1 semana sin tratamiento endoscópico

Respuesta C. Un vaso visible no sangrante (Forrest IIa) tiene alto riesgo de resangrado, por lo que requiere terapia endoscópica, idealmente combinada (adrenalina asociada a método térmico o mecánico), seguida de inhibidor de bomba de protones endovenoso en altas dosis. La cirugía y la embolización se reservan para el fracaso del tratamiento endoscópico.

▶ VER CLASE 4.01.2.005 Obstrucción Intestinal

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.4 · Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

QUÉ HAY QUE SABER

- Obstrucción intestinal: dolor cólico, vómitos, distensión y detención del tránsito de gases y deposiciones. Delgado: causas bridas (la principal) y hernias; colon: cáncer, vólvulo de sigmoides, diverticulitis.
- Examen: distensión, ruidos de lucha (metálicos) o silencio tardío; buscar cicatrices y hernias, tacto rectal (masa, ampolla vacía).
- Diagnóstico específico: Rx de abdomen de pie y acostado (asas dilatadas, niveles hidroaéreos, imagen en «grano de café» en vólvulo de sigmoides) y TAC de abdomen (sitio, causa y signos de sufrimiento).
- Estrangulación (dolor continuo, fiebre, taquicardia, peritonismo, leucocitosis, lactato elevado) es urgencia quirúrgica.
- Tratamiento inicial: régimen cero, SNG a caída libre, hidratación IV y corrección electrolítica (hipokalemia), Foley, analgesia. Seguimiento: derivar a cirugía; bridas sin estrangulación pueden manejarse conservadoramente 48-72 h; vólvulo de sigmoides: devolvulación endoscópica.

PREGUNTAS · 12

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 59

Un paciente de 60 años, que hace tres años se habría realizado una colecistectomía con coledocostomía, consulta por cuadro de dolor abdominal tipo cólico intenso, asociado a vómitos alimentarios. No ha podido eliminar gases. Al examen físico presenta dolor difuso a la palpación abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados en intensidad y tonalidad, con Blumberg presente. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Obstrucción intestinal
B Trombosis venosa mesentérica
C Embolia mesentérica
D Pancreatitis
E Diverticulitis

Respuesta A. El antecedente de cirugía abdominal previa (colecistectomía con coledocostomía) sumado a dolor cólico, vómitos, detención de gases y ruidos hidroaéreos metálicos aumentados es la presentación clásica de obstrucción intestinal por bridas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 130

Recién nacido de 4 semanas de vida presenta vómitos posprandiales abundantes, desde hace una semana, asociados a detención del incremento ponderal. La madre refiere que lo nota hambriento y toma leche ávidamente. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar radiografía de abdomen simple
B Realizar tratamiento endoscópico
C Observar evolución
D Realizar pilorotomía de Ramstedt
E Realizar funduplicatura gástrica

Respuesta D. El cuadro es una estenosis hipertrófica del píloro clásica: vómitos posprandiales abundantes desde la cuarta semana, con detención del incremento de peso y un lactante ávido por comer. De las conductas ofrecidas, la que resuelve el cuadro es la pilorotomía de Ramstedt (siempre después de corregir la hidratación y los electrolitos, aunque acá el enunciado no los mencione).

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 175

Niño de 48 horas de vida, con antecedente de síndrome de Down, presenta vómitos alimentarios explosivos, asociados a irritabilidad y decaimiento. Al examen abdominal se palpa abdomen blando, doloroso, con distensión epigástrica, que desaparece después de vomitar. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Atresia esofágica
B Hiperplasia suprarrenal congénita
C Enterocolitis necrotizante
D Atresia duodenal
E Estenosis hipertrófica del píloro

Respuesta D. Vómitos explosivos desde las primeras horas de vida, con distensión epigástrica que cede al vomitar, en un recién nacido con síndrome de Down: atresia duodenal. La radiografía mostraría la doble burbuja. La estenosis del píloro aparece más tarde, entre la segunda y la sexta semana, no a las cuarenta y ocho horas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 130

Recién nacido de 4 semanas con vómitos postprandiales abundantes desde hace una semana, asociados a detención del incremento ponderal. La madre refiere que lo nota hambriento y que toma leche con avidez. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar radiografía de abdomen simple
B Realizar tratamiento endoscópico
C Observar la evolución
D Realizar piloromiotomía de Ramstedt
E Realizar funduplicatura gástrica

Respuesta D. Cuadro clásico de estenosis hipertrófica del píloro. Lo ideal sería confirmar primero con ecografía, pero de las opciones disponibles, la piloromiotomía de Ramstedt es el tratamiento de elección (siempre corrigiendo antes la deshidratación y la alcalosis).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años, con antecedente de cirugía abdominal hace 15 años, consulta por dolor cólico, distensión y vómitos biliosos de 20 horas de evolución, sin eliminar gases ni deposiciones. Afebril, hemodinámicamente estable, abdomen distendido con ruidos hidroaéreos metálicos aumentados, sin signos de irritación peritoneal. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Laparotomía exploradora de urgencia
B Sonda nasogástrica a caída libre, hidratación endovenosa y observación
C Colonoscopía descompresiva de urgencia
D Enemas evacuantes repetidos y laxantes orales
E Antibióticos de amplio espectro y alta con control ambulatorio

Respuesta B. Obstrucción intestinal por bridas, sin signos de estrangulación (afebril, estable, sin peritonismo). El tratamiento inicial es médico conservador: sonda nasogástrica, hidratación endovenosa y vigilancia clínica durante 24 a 48 horas, ya que 70 a 80% resuelve sin cirugía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 173

Paciente con apendicectomía previa, ahora con dolor abdominal cólico, distensión progresiva y sin eliminación de gases ni heces. ¿Diagnóstico más probable?

A Obstrucción intestinal por bridas
B Vólvulo de colon sigmoide
C Ileo paralítico postoperatorio
D Hernia inguinal incarcerada
E Cáncer de colon obstructivo

Respuesta A. Diagnóstico: Obstrucción intestinal por bridas (opción A). Obstrucción intestinal por bridas. Las hernias se clasifican según su localización.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 53

Un paciente de 38 años, con antecedente de cirugía bariátrica, consulta por dolor abdominal tipo cólico y vómitos de 10 horas de evolución, que inició al día siguiente de una gran ingesta de alcohol y alimentos. Refiere que no ha eliminado gases. Al examen físico está adolorido, con FC: 106x', PA: 120/80 mmHg, T°: 37,6°C. El abdomen se aprecia distendido y es doloroso a la palpación, sin Blumberg. Se auscultan los ruidos hidroaéreos aumentados de intensidad y bazuqueo. El diagnóstico más probable es:

A Pancreatitis aguda
B Embolia mesentérica
C Úlcera gastroduodenal complicada
D Colecistitis aguda
E Obstrucción intestinal por bridas

Respuesta E. Es una obstrucción intestinal clásica, cuya causa más frecuente son las bridas (en especial en pacientes con antecedente de cirugía abdominal previa).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 73

Paciente de 68 años, sin antecedentes conocidos, consulta por cuadro de dolor abdominal desde hace 6 horas, asociado a distensión progresiva, vómitos y sensación febril, además refiere que no ha eliminado gases. Al examen físico destaca ausencia de ruidos hidroaéreos y blumberg (+). Se solicita radiografía de abdomen que se muestra a continuación:

A Gastroenteritis aguda
B Vólvulo sigmoides
C Obstrucción intestinal
D Diverticulitis aguda
E Apendicitis aguda

Respuesta C. Se ven las asas dilatadas y tiene el cuadro clínico. No se ve la imagen de grano de café, como para haber pensado en vólvulo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 128

Un paciente de 58 años presenta dolor abdominal intenso, tipo cólico, asociado a náuseas y distensión abdominal. Sus últimas deposiciones fueron hace dos días y no ha eliminado gases por ano desde ayer. Sus signos vitales muestran T°: 36,8°C, FC: 96x', PA: 144/92 mmHg, abdomen distendido, doloroso a la palpación, con signo Blumberg esbozado. En la auscultación abdominal, tiene bazuqueo intestinal y disminución de los ruidos hidroaéreos. Como antecedentes médico- quirúrgicos, es diabético, usa metformina y aspirina y se realizó apendicectomía hace 10 años. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Vólvulo de sigmoides
B Isquemia mesentérica
C Gastroenteritis aguda
D Obstrucción intestinal
E Cáncer de colon perforado

Respuesta D. Diagnóstico: Obstrucción intestinal (opción D). Las hernias se clasifican según su localización.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 117

Un paciente de 40 años con antecedente de cirugía bariátrica presenta un cuadro de 24 horas de dolor abdominal muy intenso, tipo cólico, asociado a múltiples episodios de vómitos alimentarios. Al examen físico presenta T°: 38,5°C, frecuencia cardiaca regular a 108 lpm, presión arterial de 100/60 mmHg. Al examen abdominal, se observa abdomen distendido, doloroso a la palpación, con resistencia muscular difusa, se ausculta bazuqueo intestinal y ruidos hidroaéreos intensos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Íleo mecánico por bridas
B Perforación intestinal
C Isquemia mesentérica
D Colitis isquémica
E Gastroenteritis aguda

Respuesta A. Obstrucción Intestinal por Bridas: El paciente presenta un cuadro clínico de obstrucción intestinal, caracterizado por la tríada de dolor cólico, vómitos y distensión abdominal. En este caso, la causa más probable de la obstrucción son las bridas, debido al antecedente de cirugía abdominal previa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 36

Un paciente de 56 años, con antecedente de enfermedad de Cröhn, desde los 26 años, sin tratamiento, desde hace 4 meses, presenta un cuadro de dolor abdominal y vómitos, que han ido en aumento. Sus vómitos son de tipo alimentario y al examen físico tiene PA: 110/70 mmHg, FC: 90 x', T°: 37°C, al examen abdominal se observa abdomen distendido, con auscultación de gorgoritmos y ruidos hidroaéreos intensos. Se solicita radiografía, que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A Enfermedad de Cröhn activa
B Apendicitis aguda
C Perforación intestinal
D Vólvulo de sigmoides
E Obstrucción intestinal

Respuesta E. Es una obstrucción intestinal clásica tanto por la imagen como por la clínica. En este caso, el antecedente de E. Cröhn sugiere que se complicó con una estenosis intestinal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 46

Pre unta 46 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un paciente de 80 años, consulta por dolor abdominal de 2 días de evolución, tipo cólico, intenso, al que se han agregado vómitos alimentarios importantes. El dolor es más intenso en el hemiabdomen superior. Al examen físico se aprecia paciente adolorido, con PA: 110/68 mmHg, FC: 110x', T°: 37,4. Abdomen doloroso a la palpación, con distensión abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados y sin signos de irritación peritoneal. Se solicitan exámenes entre los que destaca PCR: 10 mg/dl, hematocrito: 37%, blancos: 11.000 por mm3, plaquetas: 340.000, GOT: 66 UI/L. El diagnóstico más probable es:

A Colitis isquémica
B Trombosis de la vena mesentérica
C Perforación gástrica
D Pancreatitis aguda
E Obstrucción intestinal

Respuesta E. Diagnóstico: Obstrucción intestinal (opción E). Tiene una obstrucción intestinal clásica. Las hernias se clasifican según su localización.

▶ VER CLASE 4.01.2.006 Apendicitis aguda

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.1 · Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía
Gastroenterología 5.1 · Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Apendicitis aguda: urgencia quirúrgica más frecuente; dolor periumbilical o epigástrico que migra a fosa ilíaca derecha, anorexia, náuseas/vómitos y fiebre baja.
- Signos: dolor en punto de McBurney, Blumberg, Rovsing, psoas y obturador. Escala de Alvarado orienta (≥7 alta probabilidad).
- Diagnóstico específico: clínico + hemograma (leucocitosis con desviación izquierda) y PCR; imagen si duda: ecografía en niños, embarazadas y mujeres jóvenes; TAC en adultos (apéndice >6 mm, no compresible, con alteración de la grasa).
- Poblaciones atípicas: niños pequeños, adultos mayores y embarazadas (dolor más alto) tienen presentación atípica y más perforación; siempre β-hCG en mujer en edad fértil.
- Tratamiento inicial: régimen cero, hidratación IV, analgesia, antibiótico profiláctico (cefazolina o ceftriaxona + metronidazol). Seguimiento: derivar a cirugía para apendicectomía (laparoscópica).

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 68

Niña de 7 años con 12 horas de fiebre y dolor hipogástrico. Temperatura 38,7 grados, frecuencia cardíaca 100, presión arterial 100/60. Dolor a la palpación de hipogastrio, Blumberg positivo y resistencia de la pared abdominal. Leucocitos 18.000. Sedimento urinario con 20 leucocitos por campo. Proteína C reactiva 15. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Pielonefritis aguda
B Apendicitis aguda
C ITU baja
D Torsión ovárica
E Plastrón apendicular

Respuesta B. Fiebre, Blumberg positivo, resistencia muscular y leucocitosis marcan una irritación peritoneal focal, propia de apendicitis aguda. Los leucocitos en la orina pueden verse por vecindad de un apéndice inflamado pegado a la vejiga, y no bastan para diagnosticar una infección urinaria por sí solos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 62

Mujer de 25 años con dolor abdominal intenso, mayor en la fosa ilíaca derecha y el hipogastrio, EVA 8/10. Frecuencia cardíaca 90, presión arterial 110/70, abdomen doloroso a la palpación de ambas fosas ilíacas. Dos horas después, presenta deterioro marcado, con frecuencia cardíaca de 120 y presión arterial de 80/40. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Apendicitis aguda
B Perforación intestinal
C Torsión ovárica
D Absceso tubo-ovárico roto
E Embarazo ectópico roto

Respuesta A. El dolor bilateral en ambas fosas ilíacas con deterioro hemodinámico brusco en pocas horas corresponde a una apendicitis que perforó y generó una peritonitis con shock séptico incipiente. Los diferenciales ginecológicos no explican igual de bien la instalación tan rápida del shock sobre un dolor que ya venía siendo bilateral.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 68

Niña de 7 años de edad, quien consulta por cuadro de 12 horas de evolución, caracterizada por fiebre y dolor hipogástrico. Al examen físico tiene temperatura 38,7 grados, FC 100x', PA 100/60, dolor a la palpación de hipogastrio, con signo de Blumberg positivo y resistencia en la pared abdominal. Exámenes de laboratorio: 18.000 glóbulos blancos. Sedimento urinario muestra 20 leucocitos por campo. Proteína C reactiva 15. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Pielonefritis aguda
B Apendicitis aguda
C ITU baja
D Torsión ovárica
E Plastrón apendicular

Respuesta B. Blumberg positivo, resistencia de la pared abdominal, fiebre y leucocitosis: es una apendicitis aguda clásica. Los leucocitos en el sedimento urinario confunden con una infección urinaria, pero son un hallazgo acompañante frecuente cuando el apéndice inflamado está cerca de la vejiga, no el diagnóstico principal.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 22 años consulta por dolor que comenzó hace 14 horas en el epigastrio y hace 4 horas se trasladó a la fosa ilíaca derecha. Tiene anorexia y una náusea. Temperatura 37,6 grados, dolor exquisito en McBurney con Blumberg positivo. Leucocitos 12.500 con 78% de neutrófilos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar TAC de abdomen y pelvis antes de decidir
B Indicar profilaxis antibiótica y apendicectomía directa
C Solicitar ecografía abdominal de urgencia
D Iniciar antibióticos orales y observar 24 horas
E Solicitar radiografía simple de abdomen de pie

Respuesta B. El caso suma 8 puntos en el score de Alvarado: migración (1), anorexia (1), náuseas (1), dolor en FID (2), Blumberg (1), neutrofilia (1) y leucocitosis (2). En un hombre joven con esta clínica y score alto, la conducta es apendicectomía directa, sin necesidad de imágenes.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años con 6 días de dolor en la fosa ilíaca derecha, que comenzó en la región periumbilical. Temperatura 38 °C. Al examen se palpa una masa dolorosa en la fosa ilíaca derecha, sin signos peritoneales en el resto del abdomen. La ecografía muestra un conglomerado inflamatorio que envuelve el apéndice. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Apendicectomía de urgencia
B Antibióticos endovenosos y apendicectomía diferida a las 6–8 semanas
C Alta con analgésicos y control en 48 horas
D Colonoscopía para descartar cáncer de ciego
E Laparotomía exploradora con lavado peritoneal

Respuesta B. Masa en la FID con varios días de evolución y sin peritonitis difusa: plastrón apendicular. El epiplón contuvo el proceso; se trata con antibióticos (ceftriaxona + metronidazol) y apendicectomía diferida a las 6–8 semanas. La cirugía inmediata es para la apendicitis perforada con peritonitis difusa.

▶ VER CLASE 4.01.2.007 **Isquemia mesentérica aguda** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 5.2 · Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular

QUÉ HAY QUE SABER

- Isquemia mesentérica aguda: causa embólica (fibrilación auricular, IAM reciente; arteria mesentérica superior) la más frecuente, también trombosis arterial, trombosis venosa mesentérica e isquemia no oclusiva (shock, vasoconstrictores).
- Clave: dolor abdominal intenso, desproporcionado al examen físico (abdomen blando al inicio), en adulto mayor con FA o enfermedad cardiovascular; luego vómitos, diarrea sanguinolenta y peritonitis.
- Laboratorio: leucocitosis, acidosis metabólica con lactato elevado (tardío). Diagnóstico: angioTAC de abdomen de urgencia.
- Tratamiento inicial: reanimación con fluidos, oxígeno, anticoagulación con heparina no fraccionada IV, antibióticos de amplio espectro, régimen cero, corregir causa de bajo gasto.

- Seguimiento: derivar de inmediato a cirugía/cirugía vascular (embolectomía, revascularización, resección de intestino necrótico); mortalidad alta (>50%) y crece con el retraso.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 100

Una paciente de 65 años, con antecedente de accidente vascular encefálico con compromiso faciobraquiocrural derecho hace dos años en tratamiento con aspirina, consulta por dolor abdominal difuso e intenso de inicio agudo. Al examen físico se encuentra en regulares condiciones, ritmo irregular, abdomen levemente doloroso a la palpación profunda, Blumberg negativo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Isquemia mesentérica
B Disección aórtica
C Úlcera perforada
D Diverticulitis aguda
E Trombosis mesentérica

Respuesta A. El ritmo irregular delata la fibrilación auricular, la fuente del émbolo. El dolor es agudo y difuso, pero el abdomen está apenas doloroso y Blumberg es negativo: esa disociación clínica es la firma de la embolia de la arteria mesentérica superior. La trombosis mesentérica (E) da un cuadro más subagudo, de días, con peritoneo más precoz.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 15

Una mujer de 62 años acude al servicio de urgencia por dolor abdominal intenso, de dos horas de evolución, difuso, pero mayor en hemiabdomen superior. Además, presentó vómitos alimentarios, en varias oportunidades. El dolor inició tipo cólico, pero luego se hizo permanente. Al examen físico tiene IMC 32, temperatura 36,7 °C, frecuencia cardíaca 108x', presión arterial 102/96 mmHg. Examen cardiopulmonar normal. El examen abdominal muestra cicatriz de cesárea Pfannenstiel, timpanismo y disminución de la matidez hepática a la percusión, con ruidos hidroaéreos muy disminuidos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Obstrucción intestinal
B Perforación intestinal
C Vólvulo de sigmoides
D Trombosis de la vena mesentérica
E Embolia mesentérica

Respuesta D. La cesárea reciente es un estado protrombótico y quirúrgico, el terreno típico de la trombosis venosa mesentérica, no de la embolia (que necesita una fuente cardíaca, ausente aquí). El dolor que empieza cólico y se hace permanente, en horas, encaja con la evolución subaguda que distingue a la trombosis de la embolia súbita.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 76 años con fibrilación auricular no anticoagulada. Dolor abdominal brusco hace 4 horas, 10/10, difuso, con 2 vómitos y una deposición diarreica. Abdomen blando, depresible, levemente sensible, sin defensa ni Blumberg. Taquicárdica, lactato elevado. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Analgesia y reevaluación seriada del abdomen hasta que aparezcan signos peritoneales
B Heparina endovenosa y angio-TAC mesentérico urgente
C Colonoscopía urgente
D Hidratación y manejo como gastroenteritis aguda
E TAC de abdomen sin contraste

Respuesta B. FA no anticoagulada + dolor súbito intensísimo + abdomen blando (disociación clínica) + lactato alto: embolia de la arteria mesentérica superior. Se anticoagula con heparina ante la sospecha y se confirma con angio-TAC para revascularizar. Esperar el peritonismo es llegar con el intestino necrosado.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 70 años con ateroesclerosis, tras un episodio de hipotensión por una hemorragia digestiva, presenta dolor cólico en el flanco izquierdo y elimina deposiciones con sangre roja. Abdomen sensible en el flanco izquierdo, sin peritonismo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Embolia de la arteria mesentérica superior
B Trombosis venosa mesentérica
C Colitis isquémica
D Diverticulitis aguda
E Enfermedad de Crohn

Respuesta C. Dolor en el hemiabdomen izquierdo + hematoquecia en un adulto mayor ateroesclerótico, precipitado por hipotensión (bajo flujo): colitis isquémica de las zonas frontera. Suele ser transitoria y responde a manejo médico. La embolia da dolor más intenso y difuso, con disociación clínica, en contexto de FA.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 96

Un paciente de 66 años, hipertenso, cardiópata, en tratamiento anticoagulante por una fibrilación auricular crónica, consulta por dolor abdominal brusco, muy intenso, de 6 horas de evolución. Al examen físico presenta ritmo irregular en 2 tiempos y abdo- men doloroso a la palpación, con signos peritoneales difusos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trombosis de la vena mesentérica
B Hemoperitoneo
C Úlcera péptica perforada
D Embolia mesentérica
E Aneurisma aórtico abdominal roto

Respuesta D. Es una embolia mesentérica clásica, por la FA. Sin embargo, suele cursar sin signos peritoneales al inicio, pero había pasado ya mucho tiempo, por lo que sí aparecen di- chos signos.

▶ VER CLASE 4.01.2.008 Enfermedad diverticular complicada

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.3 · Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx

QUÉ HAY QUE SABER

- Diverticulitis complicada: con absceso, perforación (peritonitis purulenta o fecaloidea), fístula (colovesical: neumaturia y fecaluria) u obstrucción. Clasificación de Hinchey (I absceso pericólico, II pélvico/distante, III peritonitis purulenta, IV fecaloidea).
- Sospechar en dolor en fosa ilíaca izquierda con fiebre, masa palpable, signos peritoneales o compromiso sistémico; mayor riesgo en inmunosuprimidos, adultos mayores, uso de corticoides.
- Confirmación con TAC de abdomen y pelvis con contraste (engrosamiento, absceso, aire libre).
- Tratamiento inicial: hospitalizar, régimen cero, hidratación, antibióticos IV (ceftriaxona + metronidazol o piperacilina-tazobactam); absceso >3-4 cm: drenaje percutáneo.
- Seguimiento: derivar a cirugía; peritonitis (Hinchey III-IV) requiere cirugía urgente (Hartmann o resección con anastomosis); colonoscopía diferida para descartar cáncer.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 33

Un paciente de 73 años presenta un cuadro de 2 días de dolor abdominal, mayor en la fosa ilíaca izquierda. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa ilíaca izquierda, con signos de irritación peritoneal en la zona. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Apendicitis aguda
B Cáncer de colon
C Obstrucción intestinal
D Diverticulitis aguda
E Hernia inguinal complicada

Respuesta D. Dolor de 2 días en la fosa ilíaca izquierda con irritación peritoneal localizada en un adulto mayor es la presentación clásica de la diverticulitis aguda, la llamada apendicitis izquierda. Se confirma y se clasifica con TAC de abdomen y pelvis con contraste.

▶ VER CLASE 4.01.2.009 Prolapso rectal

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.7 · Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

QUÉ HAY QUE SABER

- Prolapso rectal: protrusión de todas las capas del recto a través del ano con pliegues concéntricos (vs prolapso hemorroidal o mucoso: pliegues radiales).
- Factores: mujer adulta mayor, multiparidad, constipación crónica y pujo, debilidad del piso pélvico; en niños asociado a diarrea, desnutrición y fibrosis quística (descartar con test de sudor).
- Diagnóstico específico: examen en cuclillas con pujo; evaluar incontinencia fecal asociada. Colonoscopía en adultos para descartar lesión cabeza de prolapso.
- Urgencia: prolapso irreductible, encarcelado o estrangulado (mucosa violácea/necrótica). Reducción manual suave con analgesia; el azúcar granulada sobre la mucosa reduce el edema.
- Manejo inicial: fibra, evitar pujo, tratar constipación. Seguimiento: derivar a coloproctología para cirugía (rectopexia abdominal o perineal tipo Altemeier/Delorme).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 78 años, multípara, consulta por una masa que protruye por el ano al pujar, de varios meses de evolución, con secreción mucosa e incontinencia fecal leve. Al pedirle que puje, se observa una protrusión de 6 cm, de mucosa rojiza con pliegues circulares concéntricos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hemorroides internas grado IV

B Cáncer de recto

C Pólipo rectal pediculado prolapsado

D Prolapso mucoso parcial

E Prolapso rectal completo

Respuesta E. Una protrusión de todo el espesor de la pared rectal muestra pliegues circulares concéntricos, mientras que el prolapso hemorroidal o mucoso presenta pliegues radiales. Es típico de mujeres mayores multíparas, con piso pélvico débil, y se asocia a incontinencia. El tratamiento es quirúrgico (rectopexia abdominal o técnicas perineales en pacientes de alto riesgo).

▶ VER CLASE 4.01.2.010 Trauma abdominal abierto y cerrado

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.11 · Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia
Gastroenterología 6.4 · Trauma Abdominal y Torácico

QUÉ HAY QUE SABER

- Trauma cerrado (accidentes de tránsito, caídas; bazo e hígado más afectados) vs penetrante (arma blanca o de fuego; hígado e intestino delgado). Manejo según ATLS: ABCDE.
- Sospecha: dolor, distensión, signo del cinturón de seguridad, equimosis en flancos (retroperitoneo), fracturas costales bajas, shock sin otra causa. Signo de Kehr (dolor hombro izquierdo): lesión esplénica.
- Paciente inestable: FAST (líquido libre en Morison, esplenorrenal, pelvis, pericardio) positivo → laparotomía. Estable: TAC de abdomen con contraste.
- Tratamiento inicial: 2 vías venosas gruesas, reanimación con cristaloides limitada (1 L) y transfusión precoz con relación 1:1:1 si hemorragia, ácido tranexámico 1 g IV en primeras 3 h, Foley y SNG (si no hay fractura de base de cráneo/uretra).
- Seguimiento: derivar a cirugía; indicaciones de laparotomía: inestabilidad con FAST+, peritonitis, evisceración, herida por arma de fuego. No retirar objetos empalados.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 31

Paciente sufre una herida por arma blanca en el abdomen, hace 8 horas. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y examen abdominal sin signos de irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes. Se realiza exploración digital de la herida, con anestesia local, objetivándose laceración del peritoneo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar lavado peritoneal diagnóstico

B Realizar ecografía FAST

C Suturar la herida

D Solicitar TAC abdominal

E Realizar laparoscopía exploradora

Respuesta E. La exploración local confirma que la herida penetró el peritoneo. En un paciente estable, la conducta recomendada es la laparoscopía exploradora, que confirma o descarta lesión visceral con una agresión mínima; suturar la herida sin explorar la cavidad deja pasar lesiones internas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 31

Un paciente sufre una herida por arma blanca en el abdomen, hace 8 horas. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y examen abdominal sin signos de irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes. Se realiza exploración digital de la herida, con anestesia local, objetivándose laceración del peritoneo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar lavado peritoneal diagnóstico

B Realizar ecografía FAST

C Suturar la herida

D Solicitar TAC abdominal

E Realizar laparoscopía exploradora

Respuesta E. La herida por arma blanca laceró el peritoneo: penetró la cavidad. Aunque el paciente esté estable y sin signos peritoneales, eso es indicación de exploración quirúrgica, hoy preferentemente por laparoscopía. Suturar la piel sin explorar la cavidad deja pasar una eventual lesión de intestino o mesenterio.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 26 años sufre un vuelco en automóvil, con uso de cinturón de seguridad. Ingresa pálida, con presión arterial de 84/50 y frecuencia cardíaca de 124. Se le administra 1 litro de suero Ringer Lactato, y la presión sube apenas a 88/52. El Eco-FAST muestra líquido libre en el espacio de Morrison y en la pelvis. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste

B Trasladar de inmediato a pabellón para laparotomía exploradora

C Repetir el Eco-FAST en 30 minutos y reevaluar

D Indicar 2 litros adicionales de suero fisiológico frío

E Solicitar angiografía para embolización

Respuesta B. La paciente sigue inestable pese a la reanimación inicial, con Eco-FAST positivo para hemoperitoneo. La conducta obligatoria es la laparotomía exploradora de urgencia; enviarla al TAC en ese estado es la trampa clásica y de alto riesgo vital.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años sufre un choque automovilístico de alta energía. Llega hemodinámicamente estable, con dolor leve en el hipocondrio izquierdo y sin signos peritoneales. La eco-FAST no muestra líquido libre. Las radiografías de tórax y pelvis son normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Laparotomía exploradora de urgencia

B Lavado peritoneal diagnóstico

C Observación con reevaluaciones seriadas y TAC de abdomen

D Exploración digital de la pared abdominal

E Alta con analgesia y control ambulatorio

Respuesta C. Trauma abdominal cerrado, estable, sin signos peritoneales y con eco-FAST negativa: observación con monitorización y reevaluaciones seriadas; por el mecanismo de alta energía se complementa con TAC. El lavado peritoneal está obsoleto y la exploración de la herida corresponde al arma blanca. Se operaría si apareciera inestabilidad, peritonismo o líquido libre.

▶ VER CLASE 4.01.2.011 Colecistitis aguda

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.2 · Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap

QUÉ HAY QUE SABER

- Colecistitis aguda: inflamación de la vesícula por obstrucción del cístico (litiásica >90%); dolor en hipocondrio derecho >6 h, fiebre, náuseas/vómitos, signo de Murphy positivo.
- Criterios de Tokio: signos locales (Murphy, masa/dolor en HCD) + signos sistémicos (fiebre, leucocitosis, PCR) + imagen compatible = diagnóstico definitivo.
- Ecografía: cálculos, pared vesicular >4 mm con doble halo, líquido perivesicular, Murphy ecográfico, vesícula distendida. Si duda: cintigrafía HIDA.
- Tratamiento inicial: hospitalización, régimen cero, hidratación IV, analgesia (AINE/opioide), antibióticos (ceftriaxona ± metronidazol; cefazolina en leves).
- Seguimiento: derivar a cirugía para colecistectomía laparoscópica precoz (idealmente <72 h, hasta 7 días); colecistostomía percutánea en alto riesgo quirúrgico. Complicaciones: gangrena, perforación, enfisematosa (diabéticos).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 151

Mujer de 55 años con colecistitis aguda de 48 horas de evolución. Está estable hemodinámicamente, con fiebre de 38 grados y 14.000 leucocitos. **¿Cuál es el manejo quirúrgico más adecuado?**

A Colecistectomía laparoscópica precoz, dentro de 72 horas

B Cirugía electiva en 6 semanas

C Drenaje percutáneo y cirugía diferida

D Solo antibióticos endovenosos y observación

E Colecistostomía abierta de urgencia

Respuesta A. Colecistitis aguda no complicada, paciente estable: la colecistectomía laparoscópica precoz, antes de 72 horas, es superior al manejo diferido, con menos complicaciones, menor estadía hospitalaria y menor conversión a cirugía abierta.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 50 años con 18 horas de dolor continuo en el hipocondrio derecho, fiebre de 38,2 grados y Murphy positivo. Leucocitos 13.200. La ecografía muestra un cálculo enclavado en el bacinete, pared vesicular de 5 milímetros y líquido perivesicular. No tiene falla de ningún órgano. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Hospitalizar, iniciar antibióticos y colecistectomía laparoscópica antes de 72 horas

B Indicar analgesia oral y programar cirugía electiva en 3 meses

C Realizar colecistostomía percutánea de urgencia

D Solicitar CPRE antes de cualquier cirugía

E Indicar ácido ursodesoxicólico y dieta hipograsa

Respuesta A. Colecistitis aguda Grado I de Tokio, sin falla de órganos: el tratamiento de elección es hospitalizar, iniciar antibióticos endovenosos y realizar colecistectomía laparoscópica precoz, dentro de las primeras 72 horas. La colecistostomía se reserva para el Grado III o riesgo anestésico prohibitivo, y no hay ictericia que justifique una CPRE.

▶ VER CLASE 4.01.2.012 Colangitis

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 4.1 · Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Colangitis aguda: infección de la vía biliar obstruida (coledocolitiasis la más frecuente; también estenosis, tumores, stent obstruido); E. coli, Klebsiella, Enterococcus, anaerobios.
- Tríada de Charcot: fiebre con calofríos, ictericia y dolor en hipocondrio derecho. Péntada de Reynolds (+ shock y compromiso de conciencia) indica colangitis grave.
- Diagnóstico específico (criterios de Tokio): inflamación sistémica + colestasia (bilirrubina, FA, GGT elevadas) + imagen con dilatación de vía biliar o causa (ecografía, colangio-RM). Hemocultivos.
- Tratamiento inicial: hidratación IV, antibióticos precoces (ceftriaxona + metronidazol; piperacilina-tazobactam si grave o nosocomial), corregir coagulación, manejo del shock.
- Seguimiento: derivar para drenaje biliar urgente (CPRE con papilotomía y extracción, <24 h en grave, 24-48 h en moderada); colecistectomía diferida si es litiásica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 70 años con colelitiasis conocida consulta por dolor en el hipocondrio derecho, fiebre de 39 °C con calofríos e ictericia. Se inician antibióticos endovenosos y fluidos. A las 6 horas está confusa, con PA 80/50 mmHg pese a la reposición de volumen. La ecografía muestra colédoco de 12 mm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Drenaje urgente de la vía biliar, idealmente por CPRE

B Colecistectomía laparoscópica de urgencia

C Mantener antibióticos y observar 48 horas

D Colangiorresonancia electiva

E Cambiar el antibiótico y repetir la ecografía al día siguiente

Respuesta A. La pentada de Reynolds (tríada de Charcot más compromiso de conciencia e hipotensión) define una colangitis grave. Además del soporte y los antibióticos, requiere drenaje biliar urgente, de preferencia endoscópico por CPRE (o percutáneo si no está disponible). La colecistectomía no descomprime el colédoco y se difiere hasta resolver el cuadro.

▶ VER CLASE 4.01.2.013 Pancreatitis aguda

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 4.2 · Pancreatitis Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico: 2 de 3 criterios: dolor epigástrico típico irradiado en faja/al dorso, lipasa o amilasa ≥3 veces el límite superior, imagen compatible. Causas: biliar (la más frecuente en Chile) y alcohol; también hipertrigliceridemia (>1000 mg/dl), hipercalcemia, post CPRE, fármacos.
- Estudio etiológico: ecografía abdominal en todos (litiasis), pruebas hepáticas (ALT >150 sugiere biliar), triglicéridos y calcio. TAC con contraste no es necesario al ingreso; útil a las 72 h si mala evolución (necrosis).
- Gravedad: Atlanta revisada (leve, moderada con falla orgánica transitoria <48 h o complicaciones locales, grave con falla orgánica persistente); predictores: BUN elevado, hematocrito >44%, PCR >150 a las 48 h, SIRS persistente, BISAP, Ranson, APACHE II.
- Tratamiento inicial: hidratación con Ringer lactato guiada por metas (evitar sobrecarga), analgesia (incluyendo opioides), nutrición enteral precoz cuando tolere; NO antibióticos profilácticos (solo si necrosis infectada).
- Seguimiento: derivar/hospitalizar; CPRE urgente si colangitis asociada; pancreatitis biliar leve requiere colecistectomía en la misma hospitalización. Complicaciones: colecciones, pseudoquiste, necrosis infectada.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años es hospitalizada por pancreatitis aguda leve de origen biliar. Evoluciona favorablemente: al tercer día no tiene dolor, tolera régimen oral y sus pruebas hepáticas se normalizan. La ecografía muestra colelitiasis múltiple sin dilatación de la vía biliar. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la colelitiasis?**

A Ácido ursodesoxicólico y control

B Colecistectomía electiva en 6 meses

C CPRE con papilotomía y alta

D Colecistectomía laparoscópica durante la misma hospitalización

E No operar, porque el cuadro ya se resolvió

Respuesta D. En la pancreatitis biliar leve, la colecistectomía debe realizarse durante la misma hospitalización, una vez resuelto el cuadro, porque diferirla aumenta significativamente el riesgo de recurrencia de pancreatitis y otras complicaciones biliares. En la pancreatitis grave con colecciones, en cambio, se difiere. La CPRE solo se indica ante colangitis o coledocolitiasis persistente.

▶ VER CLASE 4.01.2.014 Heridas de cara

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.18 · Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

QUÉ HAY QUE SABER

- Heridas faciales: alta vascularización (sangran mucho pero cicatrizan bien y toleran cierre primario hasta 24 h o más). Clasificar en erosión, contusa, cortante, con pérdida de tejido o por mordedura.
- Evaluar lesiones asociadas: nervio facial (movilidad), conducto parotídeo (herida en mejilla con salida de saliva), vía lagrimal (canto interno), párpado con compromiso del borde libre, fracturas faciales, TEC.
- Manejo inicial: aseo prolijo con suero fisiológico, retirar cuerpos extraños (evitar tatuaje traumático), anestesia local (lidocaína con epinefrina segura en cara), desbridamiento económico.
- Sutura: monofilamento fino (nylon 5-0 o 6-0), afrontar primero bordes anatómicos (borde bermellón del labio, ceja: no rasurar); retirar puntos a los 5 días. Profilaxis antitetánica según esquema.
- Seguimiento: derivar a cirugía plástica/maxilofacial heridas complejas, con pérdida de tejido, compromiso de nervio facial, conducto de Stenon, vía lagrimal o borde palpebral; fotoprotección de la cicatriz.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 25 años consulta 2 horas después de una caída en bicicleta con una herida cortante limpia de 2 cm en el labio superior, que cruza el borde bermellón. No hay compromiso dentario ni otras lesiones. **¿Cuál es el paso más importante en la reparación de esta herida?**

A Dejar cicatrizar por segunda intención

B Colocar el primer punto alineando exactamente el borde bermellón

C Afrontar con cianoacrilato

D Suturar solo la mucosa con material reabsorbible

E Diferir la sutura 72 horas para disminuir el riesgo de infección

Respuesta B. En las heridas de cara que cruzan el borde bermellón, el primer punto debe alinear exactamente la unión cutáneo-mucosa, porque un desnivel de apenas 1 mm produce una deformidad visible. La cara tiene excelente irrigación, por lo que estas heridas pueden suturarse en forma primaria incluso hasta 24 horas o más.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 124

Un niño de 6 años sufre un accidente en el campo, golpeándose con un palo en la cabeza y resultando con una herida supraciliar derecha de 5 cm de longitud. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Afrontamiento con cianoacrilato

B Afrontamiento con tela adhesiva

C Sutura con punto separado

D Sutura intradérmica

E Dejar que cure por segunda intención

Respuesta D. Si bien también se puede afrontar con punto separado, en pediatría y también en adultos, se prefiere la sutura intradérmica para las heridas grandes de la cara, por su mejor resultado estético.

▶ VER CLASE 4.01.2.015 Trauma maxilofacial

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.15 · Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Trauma maxilofacial: frecuente en agresiones y accidentes de tránsito; siempre descartar primero vía aérea comprometida (sangrado, fracturas inestables, caída de la lengua en fractura mandibular bilateral) y lesión de columna cervical.
- Fracturas: nasales (las más frecuentes), mandibulares (maloclusión, dolor, trismus, anestesia del mentón), cigomático-malares (aplanamiento malar, hipoestesia infraorbitaria), Le Fort I-III (movilidad del maxilar).

- Fractura del piso orbitario (blow-out): diplopía en mirada vertical, enoftalmo, hipoestesia infraorbitaria y atrapamiento del recto inferior.
- Estudio: TAC de macizo facial (de elección). Hematoma septal nasal debe drenarse precozmente (riesgo de necrosis del cartílago y nariz en silla de montar). Rinorrea clara sugiere fístula de LCR.
- Manejo inicial: asegurar vía aérea (cricotiroidotomía si no se puede intubar), control de hemorragia, analgesia, antibióticos en fracturas expuestas, profilaxis antitetánica. Seguimiento: derivar a cirugía maxilofacial/oftalmología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años recibe un puñetazo en el ojo izquierdo. Consulta por diplopía al mirar hacia arriba. Al examen presenta hematoma periorbitario, enoftalmos, limitación de la elevación del ojo izquierdo e hipoestesia de la mejilla y del labio superior ipsilaterales. Agudeza visual conservada. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Fractura del piso de la órbita (por estallido)
B Fractura de huesos propios nasales
C Fractura de mandíbula
D Parálisis del VI par craneal
E Desprendimiento de retina traumático

Respuesta A. Un golpe directo sobre el globo aumenta la presión intraorbitaria y fractura el piso orbitario (blow-out), con atrapamiento del recto inferior (diplopía en la mirada superior), enoftalmos e hipoestesia infraorbitaria por lesión del nervio infraorbitario. Se confirma con TAC de órbitas. La parálisis del VI par limita la abducción, no la elevación.

▶ VER CLASE 4.01.2.016 Traumatismo torácico grave

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.10 · Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante
Gastroenterología 6.4 · Trauma Abdominal y Torácico

QUÉ HAY QUE SABER

- Lesiones que amenazan la vida en evaluación primaria: obstrucción de vía aérea, neumotórax a tensión, neumotórax abierto, hemotórax masivo, tórax volante y taponamiento cardíaco.
- Neumotórax a tensión: diagnóstico clínico (disnea, hipotensión, ingurgitación yugular, desviación traqueal, murmullo abolido, timpanismo): descompresión inmediata con aguja (4°-5° EIC línea axilar media en adultos o 2° EIC medioclavicular) y luego tubo pleural, sin esperar Rx.
- Hemotórax masivo: >1500 ml al instalar tubo o >200 ml/h por 2-4 h → toracotomía. Neumotórax abierto: apósito oclusivo fijado en 3 lados y tubo pleural.
- Taponamiento cardíaco: tríada de Beck (hipotensión, ingurgitación yugular, ruidos apagados), FAST pericárdico; pericardiocentesis como puente y toracotomía/ventana pericárdica. Tórax volante: analgesia, oxígeno, ventilación si contusión pulmonar.
- Lesiones de evaluación secundaria: contusión pulmonar, rotura aórtica (mediastino ensanchado), lesión traqueobronquial, contusión miocárdica, rotura diafragmática y esofágica. Seguimiento: derivar a cirugía de tórax/centro de trauma.

PREGUNTAS · 9

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 71

Paciente de 25 años, tras un accidente de tránsito, llega con timpanismo a la percusión del hemitórax derecho, ausencia de murmullo vesicular derecho, disnea severa y desviación traqueal hacia la izquierda. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inmediata?**

A Neumotórax a tensión: descompresión con aguja en el 2° espacio intercostal
B Hemotórax masivo: drenaje pleural
C Contusión pulmonar: oxígeno y observación
D Fractura de costillas: analgesia
E Taponamiento cardíaco: pericardiocentesis

Respuesta A. Timpanismo con ausencia del murmullo vesicular y desviación traqueal contralateral son el cuadro clínico del neumotórax a tensión. La emergencia se resuelve con descompresión inmediata con aguja, sin esperar radiografía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 32

Paciente de 28 años sufre una puñalada en el tórax, lado derecho. Al examen físico está en buenas condiciones, con dolor torácico y presenta disminución del murmullo pulmonar, asociado a hipersonoridad a la percusión en el hemitórax derecho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Pedir radiografía de tórax
B Pedir resonancia magnética de tórax
C Instalar un tubo pleural de inmediato
D Solicitar TAC de tórax
E Realizar videotoracoscopía

Respuesta A. Hay un neumotórax traumático, pero sin los signos de tensión: el paciente está en buenas condiciones, sin hipotensión ni desviación traqueal. Sin esa urgencia, sí corresponde pedir primero la radiografía, para ver el grado del neumotórax y descartar un hemotórax asociado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 102

Mujer de 56 años ingresa tras un accidente automovilístico de alta energía, con hemorragia masiva e inestabilidad hemodinámica. Las imágenes muestran un hematoma subdural con desplazamiento de 11 mm, múltiples fracturas costales con neumotórax izquierdo y desviación traqueal hacia la derecha, y una fractura de pelvis desplazada. **¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas es la más urgente?**

A Intubación orotraqueal
B Laparotomía exploradora
C Evacuación quirúrgica del hematoma subdural
D Pleurostomía izquierda
E Estabilización de la fractura de pelvis

Respuesta D. De todas las lesiones, la que mata primero es el neumotórax a tensión, evidenciado por la desviación traqueal. El hematoma subdural y la fractura de pelvis son graves, pero no matan en el mismo minuto: se tratan una vez resuelta la lesión torácica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 32

Un paciente de 28 años sufre una puñalada en el tórax, en el lado derecho. Al examen físico está en buenas condiciones, con dolor torácico, y presenta disminución del murmullo pulmonar, asociado a hipersonoridad a la percusión en el hemitórax derecho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Pedir radiografía de tórax
B Pedir resonancia magnética de tórax
C Instalar un tubo pleural
D Solicitar TAC de tórax
E Realizar videotoracoscopía

Respuesta A. Trauma torácico penetrante con clínica de neumotórax (murmullo pulmonar disminuido e hipersonoridad), en un paciente estable, sin signos de neumotórax a tensión: el primer paso es la radiografía de tórax, para confirmar el diagnóstico y ver la magnitud antes de decidir el tubo pleural.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 123

Un paciente de 32 años sufre accidente de tránsito, golpeándose el pecho contra el piso. Algunos minutos después evoluciona con dificultad respiratoria, malestar general y compromiso del nivel de conciencia, siendo llevado al servicio de urgencias. Se constata frecuencia cardíaca: 140 por minuto, presión arterial: 86/50 mmHg, frecuencia respiratoria: 45 respiraciones por minuto y saturación de oxígeno: 82% a aire ambiental. En el examen segmentario, se observa ingurgitación yugular con desviación de la tráquea y se ausculta disminución del murmullo pulmonar derecho y ruidos cardíacos apagados. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Contusión pulmonar
B Taponamiento cardíaco
C Disección aórtica
D Neumotórax hipertensivo
E Hemotórax masivo

Respuesta D. Shock + ingurgitación yugular + desviación traqueal + murmullo disminuido: neumotórax a tensión. El taponamiento también da taquicardia, hipotensión, yugulares ingurgitadas y ruidos apagados, pero no desvía la tráquea ni disminuye el murmullo. Se descomprime de inmediato.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 71

Paciente de 25 años tras accidente de tránsito llega con timpanismo a la percusión del hemitórax derecho, ausencia de murmullo vesicular derecho, disnea severa y desviación traqueal hacia la izquierda. **¿Cuál es el diagnóstico y conducta inmediata?**

A Neumotórax a tensión: descompresión con aguja en 2° espacio intercostal
B Hemotórax masivo: drenaje pleural
C Contusión pulmonar: oxígeno y observación
D Fractura de costillas: analgesia
E Taponamiento cardíaco: pericardiocentesis

Respuesta A. Timpanismo + murmullo ausente + desviación traqueal contralateral = neumotórax a tensión. Emergencia: descompresión inmediata con aguja en el 2.º espacio intercostal, línea medioclavicular, sin esperar la radiografía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 102

Una paciente de 56 años ingresa al servicio de urgencias tras sufrir un accidente automovilístico de alta energía. Presenta múltiples lesiones, hemorragia masiva, taquicardia, hipotensión e inestabilidad hemodinámica. Se sospecha una fractura de pelvis en el examen físico. Se solicitan imágenes, entre las que se informan una TAC cerebral con un hematoma subdural izquierdo con desplazamiento de 11 mm desde la línea media de la masa encefálica; una TAC de tórax revela múltiples fracturas costales, neumotórax izquierdo con desplazamiento de la tráquea hacia la derecha; TAC de abdomen y pelvis con fractura de pelvis desplazada. **¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas es la más urgente?**

A Intubación orotraqueal
B Laparotomía exploradora
C Evacuación quirúrgica del hematoma subdural
D Pleurostomía izquierda
E Estabilización de la fractura de pelvis con un dispositivo de compresión neumática

Respuesta D. Entre múltiples lesiones graves, la más urgente es el neumotórax a tensión (desviación traqueal contralateral + hipotensión). Entre las alternativas, la pleurostomía izquierda es la medida prioritaria; si hubiera estado disponible, la descompresión con aguja iría primero.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Paciente de 40 años con trauma torácico cerrado. La radiografía muestra una opacidad de la base derecha con borramiento del ángulo costofrénico. Se instala un tubo pleural que drena 1.800 mL de sangre en la primera hora. **¿Cuál es la conducta?**

A Mantener el tubo pleural y observar

B Toracotomía (exploración quirúrgica)

C Transfundir glóbulos rojos y reevaluar en 6 horas

D Retirar el tubo e instalar uno de mayor calibre

E TAC de tórax con contraste antes de decidir

Respuesta B. Hemotórax con salida inicial mayor de 1.500 mL por el tubo pleural (o débito sostenido de más de 200 mL/h por 2–4 horas): hemorragia activa importante, indicación de toracotomía. Mantener solo el drenaje o transfundir sin controlar la fuente lleva al shock; el TAC no debe retrasar la cirugía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 33

Hombre politrauma se hace TAC hematoma epidural + neumotórax con desviación de tráquea + derrame pericardico extenso, que vuelve del TAC con deterioro hemodinamico. Conducta inicial: a. Pleurostomía

B Reanimación

C Pericardiocentesis yo puse pericardiocentesis, porque si es un NT a tensión necesita la punción con aguja antes q una pleurostomía

C Laparotomía exploratoria

D Cirugía laparoscópica

E Manejo conservador

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Pericardiocentesis yo puse pericardiocentesis, porque si es un NT a tensión necesita la punción con aguja antes q una pleurostomía (opción C).

▶ VER CLASE 4.01.2.017

Supuración pulmonar

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Respiratorio 2.3 · Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa
Respiratorio 2.4 · Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares

QUÉ HAY QUE SABER

- Absceso pulmonar: necrosis del parénquima con cavidad, generalmente por aspiración de flora oral anaerobia (alcohólicos, trastornos de conciencia, mala higiene dental, disfagia); segmentos posteriores de lóbulos superiores y apicales de inferiores.
- Clínica subaguda: fiebre, tos con expectoración purulenta y fétida (vómica), baja de peso; Rx: cavidad con nivel hidroaéreo de pared gruesa.
- Empiema: pus en espacio pleural, habitualmente complicación de neumonía; sospechar con fiebre persistente pese a antibióticos y derrame pleural. Diagnóstico con toracocentesis (pus, pH <7,2, glucosa <60).
- Tratamiento inicial: antibióticos prolongados (clindamicina 600 mg c/8 h IV o amoxicilina-ácido clavulánico; ampicilina-sulbactam IV) por 4-6 semanas en absceso; drenaje pleural con tubo en empiema.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar/cirugía de tórax; descartar cáncer (fibrobroncoscopía) y TBC si no responde o en fumador mayor. Bronquiectasias infectadas también son supuración pulmonar.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 62 años con etilismo crónico severo, que sufrió una pérdida de conciencia tras una ingesta alcohólica copiosa. Tres días después consulta por fiebre de 38,8 °C, tos con expectoración purulenta de olor fétido y dolor torácico derecho. Rx de tórax: condensación con broncograma aéreo en el segmento apical del lóbulo inferior derecho. **¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico más adecuado?**

A Azitromicina 500 mg al día por vía oral

B Ampicilina/sulbactam endovenoso

C Ciprofloxacino en monoterapia oral

D Amikacina intramuscular diaria

E Amoxicilina 1 g cada 8 horas oral

Respuesta B. Neumonía aspirativa: pérdida de conciencia por alcohol, esputo fétido (anaerobios) y condensación en el segmento apical del lóbulo inferior derecho (declive en decúbito supino). El esquema debe cubrir anaerobios y flora oral: ampicilina/sulbactam EV (o amoxicilina/clavulánico).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 50 años, alcohólico, en tratamiento por absceso pulmonar periférico del lóbulo inferior derecho. Al día 6 presenta bruscamente dolor torácico derecho intenso, disnea y fiebre de 39 °C. FR 30/min, SatO2 89 %. Radiografía: nivel hidroaéreo amplio en el espacio pleural derecho, con colapso pulmonar parcial. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener antibióticos y repetir radiografía en 48 horas

B Punción con aguja en el 2.º espacio intercostal y alta

C Fibrobroncoscopía para drenar el absceso

D Instalar tubo de drenaje pleural de urgencia

E Lobectomía inferior derecha de urgencia como primera medida

Respuesta D. La ruptura de un absceso periférico a la pleura produce un pioneumotórax: aire y pus en el espacio pleural, con nivel hidroaéreo pleural. Es una supuración pleuropulmonar que exige drenaje pleural con tubo grueso de inmediato, además de antibióticos. La cirugía queda para fracaso del drenaje.

▶ VER CLASE 4.01.2.018 Hemoptisis masiva

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.5 · Hemoptisis y Bronquiectasias

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemoptisis masiva: >200-600 ml en 24 h o cualquier volumen que compromete la vía aérea o la hemodinamia; la muerte es por asfixia, no por exanguinación. Origen habitual en arterias bronquiales.
- Causas: bronquiectasias, TBC (activa o secuelas, incluido aspergiloma), cáncer pulmonar, absceso, coagulopatía. Diferenciar de hematemesis y sangrado nasofaríngeo.
- Manejo inicial: asegurar vía aérea, oxígeno, decúbito lateral sobre el lado sangrante (pulmón sano arriba), 2 vías venosas, hemograma, coagulación, grupo y Rh; corregir coagulopatía; ácido tranexámico puede ayudar.
- Intubación con tubo grueso (permite fibrobroncoscopía) o selectiva del pulmón sano si sangrado incontrolable.
- Seguimiento: derivar a UCI/broncopulmonar: angioTAC, fibrobroncoscopía para localizar, embolización de arterias bronquiales (de elección) o cirugía de resección.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 50 años con bronquiectasias en el lóbulo inferior izquierdo presenta hemoptisis de aproximadamente 400 mL en 6 horas. Está consciente, con SatO2 de 91% y PA 120/75 mmHg. **¿Cuál es la medida inicial más adecuada mientras se gestiona el estudio y tratamiento definitivo?**

A Posición de Trendelenburg

B Posición en decúbito lateral derecho

C Posición en decúbito lateral izquierdo, sobre el lado que sangra

D Nebulización con broncodilatadores

E Kinesioterapia respiratoria con percusión

Respuesta C. En la hemoptisis masiva lo prioritario es proteger la vía aérea del pulmón sano: se ubica al paciente en decúbito lateral sobre el lado que sangra para evitar la aspiración de sangre al pulmón contralateral, con oxígeno y eventual intubación. Luego, broncoscopía y angioTAC permiten localizar la lesión para embolización de arterias bronquiales o cirugía.

▶ VER CLASE 4.01.2.019 Perforación esofágica - Mediastinitis

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.4 · Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico

QUÉ HAY QUE SABER

- Perforación esofágica: causa más frecuente iatrogénica (endoscopía, dilatación); síndrome de Boerhaave por vómitos intensos (perforación distal izquierda, típico tras comida abundante y alcohol); también cuerpos extraños, trauma.
- Clínica: dolor torácico intenso retroesternal posterior a vómitos o procedimiento, disnea, fiebre, enfisema subcutáneo cervical (tríada de Mackler: vómitos, dolor torácico, enfisema subcutáneo).
- Rx de tórax: neumomediastino, derrame pleural izquierdo, hidroneumotórax; confirmar con esofagograma con contraste hidrosoluble o TAC con contraste oral.
- Mediastinitis: complicación grave (también por infecciones odontogénicas descendentes o post esternotomía), con sepsis y alta mortalidad.
- Tratamiento inicial: régimen cero, hidratación, antibióticos IV de amplio espectro (incluir anaerobios ± antifúngico), IBP, soporte. Seguimiento: derivar a cirugía de tórax urgente (reparación, drenaje, stent).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 154

Paciente de 43 años, con epigastralgia desde hace 3 semanas, a quien se le realiza endoscopía digestiva alta por sospecha de úlcera, que muestra gastritis erosiva con test de ureasa positivo, por lo que se indica tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. Tres horas después del procedimiento, evoluciona con dolor torácico irradiado a hombro derecho y sensación febril. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico en este caso?**

A Radiografía de tórax

B Repetir la endoscopía

C Tomografía axial computada de tórax

D Radiografía baritada de esófago-estómago-duodeno

E Electrocardiograma

Respuesta C. Dolor torácico y fiebre pocas horas después de una endoscopía es una perforación esofágica iatrogénica, la causa más frecuente de este cuadro, con sospecha de mediastinitis secundaria. El TAC de tórax es el examen que mejor confirma el neumomediastino y la extensión del daño; la radiografía simple puede no mostrarlo si el cuadro es muy reciente.

▶ VER CLASE 4.01.2.020 Traumatismo raquimedular

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar lesión raquimedular en todo politraumatizado, trauma de alta energía, caída de altura, TEC, intoxicado o con dolor cervical/dorsal, déficit neurológico o priapismo. Inmovilizar hasta descartar.
- Shock neurogénico (lesión sobre T6): hipotensión con bradicardia y piel caliente por pérdida del tono simpático; diferenciar de shock hipovolémico (taquicardia, piel fría) que es más frecuente en trauma.
- Shock medular: pérdida transitoria de reflejos y flacidez bajo la lesión. Lesiones incompletas: centromedular (más en extremidades superiores), anterior, Brown-Séquard.
- Imagen: reglas NEXUS o canadiense para indicar estudio; TAC de columna es el examen de elección en trauma; RM para lesión medular o ligamentosa.
- Manejo inicial: inmovilización con collar y tabla, movilización en bloque, ABC con vía aérea con control cervical, evitar hipotensión (PAM >85 mmHg) e hipoxia, Foley; corticoides NO se recomiendan de rutina. Seguimiento: derivar a neurocirugía/traumatología. GES politraumatizado grave.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 28 años sufre una caída de 5 metros. Ingresa con vía aérea permeable, sin lesiones torácicas ni abdominales evidentes y eco-FAST negativa. Presenta PA 80/45 mmHg, FC 52 lpm, piel tibia y seca, y paraplejia con arreflexia de las cuatro extremidades. **¿Cuál es el tipo de shock más probable?**

A Shock hipovolémico hemorrágico

B Shock séptico

C Shock cardiogénico

D Shock neurogénico

E Shock obstructivo por neumotórax a tensión

Respuesta D. La lesión medular cervical o torácica alta interrumpe el tono simpático: hipotensión con bradicardia y piel tibia y seca caracterizan al shock neurogénico, a diferencia del hemorrágico, que cursa con taquicardia y piel fría. Se maneja con volumen prudente y vasopresores, inmovilización espinal y búsqueda activa de hemorragia oculta antes de atribuir todo a la médula.

▶ VER CLASE 4.01.2.021 Insufic. arterial aguda: embolia, trombosis, traumatismos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.4 · Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial

QUÉ HAY QUE SABER

- Isquemia arterial aguda: oclusión súbita por embolia (FA, IAM reciente; inicio brusco, sin historia de claudicación, pulsos contralaterales normales) o trombosis sobre placa (historia de claudicación, ausencia de pulsos contralaterales), o trauma.
- Las 6 P: dolor (pain), palidez, ausencia de pulsos, parestesias, parálisis y poiquilotermia (frialdad). Parestesias y parálisis indican amenaza de la viabilidad.
- Clasificación de Rutherford: I viable, IIa marginalmente amenazada, IIb amenaza inmediata (requiere revascularización urgente), III irreversible (amputación).
- Tratamiento inicial: heparina no fraccionada IV en bolo (5.000-10.000 UI o 80 UI/kg) y luego infusión, analgesia, extremidad en declive y protegida (no calor local, no elevar), hidratación.
- Seguimiento: derivar de inmediato a cirugía vascular (embolectomía con catéter de Fogarty, trombólisis o bypass); ventana de ~6 horas. Riesgo de síndrome de reperfusión (hiperkalemia, mioglobinuria) y compartimental.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 30 años sufre una fractura de antebrazo en un accidente. En el servicio de urgencia tiene una herida de la cual sale sangre en chorro, a ritmo del pulso. Está pálido y taquicárdico. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Ligadura inmediata de la arteria

B Compresión directa de la herida

C Instalar un torniquete de inmediato

D Elevar el brazo y esperar

E Solicitar una arteriografía antes de actuar

Respuesta B. La hemorragia pulsátil indica lesión arterial. La prioridad es la compresión directa, dentro del ABC del trauma. El torniquete se reserva para una hemorragia exanguinante que no cede, y la ligadura es un último recurso. La reparación definitiva es quirúrgica.

▶ VER CLASE 4.01.2.022 **Aneurisma de aorta abdominal** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 5.4 · Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal

QUÉ HAY QUE SABER

- Aneurisma de aorta abdominal (AAA): dilatación ≥3 cm, generalmente infrarrenal; factores: hombre >65 años, tabaco (principal), HTA, aterosclerosis, antecedente familiar.
- Mayoría asintomático: masa pulsátil expansiva periumbilical. Diagnóstico específico: ecografía abdominal (tamizaje y seguimiento); angioTAC para planificación.
- Rotura: tríada de dolor abdominal o lumbar súbito, hipotensión/shock y masa pulsátil; puede confundirse con cólico renal en adulto mayor. Emergencia: mortalidad >80%.
- Manejo inicial del AAA roto: hipotensión permisiva (PAS ~70-90 mmHg, evitar sobrehidratar), 2 vías venosas, transfusión, traslado inmediato a cirugía vascular. Si estable con dudas: angioTAC.
- Seguimiento: derivar a cirugía vascular; reparación electiva (abierta o endovascular EVAR) si ≥5,5 cm en hombres (≥5 cm en mujeres), crecimiento >1 cm/año o sintomático; menores: control ecográfico, cese tabaco, estatina y control de PA.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 5.4

Hombre de 68 años fumador asintomático es derivado por hallazgo ecográfico de un Aneurisma de Aorta Abdominal infrarrenal de 5.8 cm de diámetro transversal máximo. ¿Cuál es la conducta médica indicada?

A Derivación a cirugía vascular para resolución quirúrgica o endovascular (EVAR)

B Control ecográfico anual para vigilar crecimiento

C Iniciar anticoagulación oral con Warfarina

D Indicar reposo en cama permanente

E Tratamiento con dosis altas de estatinas sin intervención

Respuesta A. El umbral de diámetro para indicar la reparación quirúrgica profiláctica o endovascular (EVAR) de un aneurisma de aorta abdominal en hombres es de ≥ 5.5 cm (o ≥ 5.0 cm en mujeres), dado que sobre este tamaño el riesgo anual de rotura fatal supera los riesgos inherentes al procedimiento quirúrgico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 65

Un paciente de 77 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertesión ar- terial, consulta por dolor abdominal de tipo inespecífico, de 2 meses de evolución, sin otros síntomas. En su examen físico se palpa un tumor abdominal de 4 a 5 cm de diáme- tro, en la zona umbilical, pulsátil, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trombosis mesentérica

B Tumor de colon

C Tumor de páncreas

D Disección aórtica

E Aneurisma aórtico abdominal

Respuesta E. Diagnóstico: Aneurisma aórtico abdominal (opción E). Un tumor pulsátil en esa zona, hace pensar en un AAA. El aneurisma de aorta abdominal (AAA) es una dilatación permanente de la aorta abdominal mayor a 3 cm o 1,5 veces el diámetro normal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 86

Un paciente de 41 años, con antecedente de riñón poliquístico del adulto, acude al servicio de urgencia por dolor epigástrico intenso asociado a malestar general. Al examen físico presenta frecuencia cardíaca 105 por minuto, presión arterial 90/60 mmHg, temperatura 36,2 °C y examen abdominal con abdomen depresible, con presencia de signos peritoneales esbozados en abdomen superior. Se palpan masas en ambos flancos y en el epigastrio. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran amilasa 160 U/L (valor normal 60 - 140 U/L), glicemia 110 mg/dL, GOT 50 U/L, creatinina: 2,5 mg/dL, BUN: 48 mg/dL y troponinas negativas. ¿Cuál es el examen imagenológico de elección para iniciar el estudio en este paciente?

A Ecogra:a abdominal
B PieloTAC
C UroTAC
D Ecocardiogra:a transesofágica
E Resonancia magné2ca nuclear de abdomen

Respuesta A. Es una pregunta difícil, pero el diagnóstico de sospecha es una aneurisma aórtico abdominal (AAA) roto. El examen inicial es la ecografía abdominal de urgencia. El AAA se asocia a RPQ. La masa epigástrica es el AAA y las masas en ambos flancos son los riñones aumentados de tamaño por la enfermedad poliquística. El RPQ también se asocia a disección aórtica (se estudiaría con ecocardiografía transesofágica), pero, su cuadro clínico es distinto, con dolor torácico.

▶ VER CLASE 4.01.2.023 Traumatismos vasculares

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.4 · Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial

QUÉ HAY QUE SABER

- Trauma vascular periférico por heridas penetrantes (arma blanca/fuego) o trauma cerrado (luxación de rodilla → arteria poplítea; fractura supracondílea de húmero → arteria braquial).
- Signos duros (cirugía inmediata): hemorragia pulsátil, hematoma expansivo, ausencia de pulsos distales, soplo o frémito, isquemia distal.
- Signos blandos (estudiar con índice de presión arterial <0,9, Doppler o angioTAC): hematoma estable, déficit neurológico adyacente, pulso disminuido, herida en trayecto vascular, hipotensión inexplicada.
- Manejo inicial: compresión directa de la hemorragia; torniquete si sangrado de extremidad no controlable (anotar hora de instalación); no pinzar a ciegas; reanimación y reducir/alinear fracturas y luxaciones.
- Seguimiento: derivar a cirugía vascular (reparación, injerto venoso, shunt temporal); fasciotomía si riesgo de síndrome compartimental tras reperfusión.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 22 años sufre una herida por arma blanca en la cara medial del muslo derecho. Ingresa con un hematoma pulsátil que aumenta de tamaño, frémito palpable y ausencia de pulsos poplíteo y pedio en esa extremidad. PA 110/70 mmHg tras la reanimación inicial. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Medir el índice tobillo-brazo y reevaluar en 6 horas
B Exploración quirúrgica vascular inmediata
C AngioTAC electiva al día siguiente
D Vendaje compresivo y alta con control
E Ecografía Doppler venosa

Respuesta B. Los signos duros de lesión vascular (hemorragia pulsátil, hematoma expansivo, frémito o soplo, ausencia de pulsos distales o isquemia) indican exploración quirúrgica inmediata, sin necesidad de imágenes previas. El índice tobillo-brazo o la angioTAC se usan ante signos blandos, como un hematoma estable o un déficit neurológico vecino.

▶ VER CLASE 4.01.2.024 Hemorragia aguda post operatoria.

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.16 · Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs)

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemorragia postoperatoria precoz (primeras 24 h): generalmente falla técnica de hemostasia (ligadura deslizada); tardía: infección, coagulopatía o dehiscencia.
- Signos: taquicardia (signo precoz), hipotensión, oliguria, palidez, débito hemático abundante por drenajes, hematoma de herida o distensión abdominal; caída de hemoglobina (puede tardar en reflejarse).
- Diagnóstico específico: control de signos vitales, hemograma seriado, pruebas de coagulación (TP, TTPA, plaquetas), revisar uso de anticoagulantes/antiagregantes; ecografía/FAST o TAC si sangrado interno y estabilidad.
- Tratamiento inicial: 2 vías venosas, cristaloides y transfusión de glóbulos rojos, corregir coagulopatía (plasma, plaquetas, vitamina K, protamina si heparina), compresión local de hematoma superficial, ácido tranexámico.
- Seguimiento: avisar y derivar al cirujano tratante: reintervención si inestabilidad, sangrado persistente o hematoma que compromete (p. ej., cuello post tiroidectomía: abrir la herida de inmediato por compromiso de vía aérea).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 148

Paciente apendicectomizado hace 6 horas evoluciona con malestar general y dolor abdominal. Su pulso es regular, de 120 lpm, y su presión arterial es 90/50 mmHg. Al examen abdominal presenta dolor y signos peritoneales en el hemiabdomen inferior. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hemoperitoneo
B Evisceración
C Trombosis de la vena porta
D Dehiscencia de la base apendicular
E Tromboembolismo pulmonar masivo

Respuesta A. Taquicardia, hipotensión y signos peritoneales en las primeras horas tras una cirugía abdominal sugieren hemorragia postoperatoria (hemoperitoneo), habitualmente por falla en la ligadura del meso o la arteria apendicular, y requiere reoperación. La dehiscencia del muñón suele aparecer después de 3 a 5 días, con fiebre y peritonitis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 87

Un paciente de 42 años, con diagnóstico de hernia inguinal derecha, es sometido a hernioplas`a a las 8:00 horas del día de hoy. Evoluciona favorablemente en el postoperatorio inmediato y es dado de alta a las 15:00 horas. Reingresa a las 21:00 horas al servicio de urgencia por dolor intenso en la zona, EVA 7/10. Al examen físico, sus signos vitales muestran temperatura 37,1 °C, frecuencia cardíaca 100 por minuto y presión arterial 120/78 mmHg; se aprecia aumento de volumen inguinal doloroso a la palpación, con eritema de la piel. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Absceso inguinal
B Hematoma inguinal
C Hernia crural atascada
D Cuerpo extraño
E Recurrencia de la hernia inguinal

Respuesta D. El diagnóstico más probable es un hematoma inguinal postoperatorio, dado el inicio precoz del dolor y aumento de volumen pocas horas después de la hernioplastia. La presencia de eritema local puede explicarse por inflamación secundaria a la colección hemática. Los abscesos y la reacción inflamatoria al cuerpo extraño suelen presentarse de forma más tardía.

▶ VER CLASE 4.01.2.025 Heridas y contusiones menores

DX ESPECÍFICO · TX COMPLETO · SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.18 · Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

QUÉ HAY QUE SABER

- Clasificar: erosión/abrasión, herida cortante, contusa, punzante, con pérdida de sustancia, por mordedura; limpia (<6 h, sin contaminación) vs contaminada. Contusiones: equimosis y hematoma sin solución de continuidad.
- Evaluar compromiso de tendones, nervios (sensibilidad distal antes de anestesiar), vasos y articulaciones; Rx si sospecha de cuerpo extraño o fractura.
- Tratamiento completo: anestesia local (lidocaína 1-2%, máx 4,5 mg/kg; 7 mg/kg con epinefrina), aseo abundante con suero fisiológico, desbridamiento, cierre primario si <6-8 h (hasta 24 h en cara); mordeduras y heridas muy contaminadas: cierre diferido o por segunda intención (salvo cara).
- Retiro de puntos: cara 5 días, cuero cabelludo y tronco 7-10, extremidades 10-14, articulaciones 14. Antibiótico profiláctico en mordeduras (amoxicilina-ácido clavulánico 3-5 días) y heridas muy contaminadas.
- Prevención: profilaxis antitetánica según esquema y tipo de herida; evaluar antirrábica en mordeduras. Contusiones: frío local, reposo, AINE. Seguimiento: control de herida a las 48 h en APS.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 40 años consulta por una herida cortante de 5 cm en la pierna, producida con un vidrio sucio hace 20 horas. Los bordes están levemente eritematosos, con restos de tierra, sin compromiso de estructuras profundas. Tiene esquema antitetánico completo con refuerzo hace 2 años. **¿Cuál es el manejo más adecuado de la herida?**

A Sutura primaria inmediata tras un aseo breve
B Antibiótico oral y sutura primaria
C Cierre con adhesivo tisular
D Aseo quirúrgico con debridamiento, no cerrar en forma primaria, curaciones y cierre diferido o por segunda intención
E Vendaje compresivo sin aseo

Respuesta D. Una herida contaminada y de más de 12 a 24 horas de evolución, en zona no facial, tiene alto riesgo de infección si se cierra primariamente. Se realiza aseo profuso y debridamiento, se deja abierta con curaciones y se cierra en forma diferida o por segunda intención.

▶ VER CLASE 4.01.2.026 Quemaduras

DX ESPECÍFICO · TX INICIAL · SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.13 · Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Profundidad (clasificación de Benaim/Converse): A o 1° (eritema, dolor), AB superficial o 2° superficial (flictenas, rosado, muy doloroso), AB profunda (blanco-rosado, menos doloroso), B o 3° (blanco nacarado o carbonizado, indoloro, acartonado).

- Extensión: regla de los 9 de Wallace en adultos (cabeza 9%, cada brazo 9%, tronco anterior 18%, posterior 18%, cada pierna 18%, periné 1%); palma del paciente ≈1% para quemaduras parcheadas; Lund-Browder en niños.
- Gran quemado (GES): índice de gravedad de Garcés >70 (mayor de 20 años), quemadura AB/B >20% SCQ, o de vía aérea, eléctrica de alta tensión o en zonas especiales (cara, manos, pies, genitales, pliegues).
- Manejo inicial: ABCDE; sospecha de quemadura de vía aérea (incendio en espacio cerrado, hollín, vibrisas quemadas, disfonía) → intubación precoz; oxígeno al 100% por CO; detener el proceso (retirar ropa, irrigar con agua tibia).
- Reposición: Parkland 4 ml × kg × %SCQ de Ringer lactato en 24 h (mitad en primeras 8 h), ajustado a diuresis 0,5 ml/kg/h (1 ml/kg/h en niños y eléctricas); analgesia con opioides, profilaxis antitetánica, cubrir con apósitos limpios. Seguimiento: derivar a unidad de quemados.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 77

Niño con quemadura en palmas y dedos, con eritema importante y ampollas, que llega a urgencias inquieto e irritable. **¿Cuál es la conducta inicial?**

A Aplicar apósitos de plata y hospitalizar
B Enfriar con agua fría y cubrir con gasa estéril
C Indicar analgesia endovenosa
D Hospitalizar para manejo de quemaduras
E Debridación bajo anestesia general inmediata

Respuesta C. Antes de cualquier cálculo, examen o curación, el paciente quemado necesita analgesia endovenosa: el dolor de las quemaduras es intenso y tratarlo primero facilita todo lo que viene después, incluyendo la evaluación de la extensión y la profundidad.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 28 años sufre quemaduras por líquido caliente hace 3 horas. Presenta flictenas húmedas y rosadas, muy dolorosas, en todo el tronco anterior y en toda una extremidad inferior. No tiene compromiso facial ni de la vía aérea. Pesa 60 kg. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Manejo ambulatorio con analgesia oral y curaciones
B Calcular Parkland con 36 % de superficie quemada y derivar como gran quemada
C Calcular Parkland con 18 % de superficie quemada y derivar como gran quemada
D Indicar antibióticos profilácticos y control ambulatorio en 48 horas
E Realizar escarotomía profiláctica antes de cualquier examen

Respuesta B. Tronco anterior (18 %) más una extremidad inferior completa (18 %) suman 36 % de superficie quemada de segundo grado, que supera el 20 % que define gran quemado en adultos. Se calcula Parkland con ese 36 % y se activa el traslado GES. La escarotomía no aplica: no hay escara circular de tercer grado.

▶ VER CLASE 4.01.2.027 Trauma

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Trauma es principal causa de muerte en <40 años; distribución trimodal (inmediata, primeras horas = «hora de oro», tardía por sepsis/falla multiorgánica). Manejo con protocolo ATLS.
- Evaluación primaria ABCDE: vía aérea con control de columna cervical, ventilación, circulación con control de hemorragia, déficit neurológico (Glasgow, pupilas), exposición con control de hipotermia.
- Shock en trauma es hemorrágico hasta demostrar lo contrario; buscar sangrado en tórax, abdomen, pelvis, huesos largos y externo. Clasificación de hemorragia ATLS I-IV.
- Adjuntos: monitoreo, Foley y SNG (si no hay contraindicación), Rx de tórax y pelvis, FAST. Luego evaluación secundaria (cabeza a pies, AMPLE).
- Manejo inicial: oxígeno, 2 vías venosas gruesas, cristaloides tibios limitados, transfusión precoz, ácido tranexámico, inmovilización. Seguimiento: derivar a centro de trauma; politraumatizado grave es GES.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 34 años, motociclista, sufre una colisión de alta energía. Tras una hora de cirugía por una laceración hepática, el anestesista informa temperatura de 34,2 grados, pH arterial de 7,15 y sangrado difuso en napa desde toda la herida operatoria, sin que ningún vaso puntual esté sangrando. **¿Cuál es la conducta quirúrgica más adecuada en este momento?**

A Continuar la reconstrucción hepática definitiva hasta terminarla
B Empaquetar la cavidad con compresas, cerrar en forma temporal y trasladar a la unidad de paciente crítico
C Administrar bicarbonato de sodio y seguir operando sin cambios
D Realizar un bypass vascular y cerrar la pared por planos
E Esperar en pabellón a que la temperatura se normalice sola

Respuesta B. Hipotermia, acidosis y sangrado difuso en napa son la tríada letal instalada. Continuar la cirugía definitiva es lo que más se pregunta como error: la conducta correcta es la cirugía de control de daños, con packing, cierre temporal y traslado a la unidad de paciente crítico.

▶ VER CLASE 4.01.2.028 Intoxicación por anestésicos locales

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.15 · Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales

QUÉ HAY QUE SABER

- Toxicidad sistémica por anestésicos locales: por inyección intravascular inadvertida o sobredosis; dosis máximas: lidocaína 4,5 mg/kg (máx 300 mg) sin epinefrina y 7 mg/kg (máx 500 mg) con epinefrina; bupivacaína 2-2,5 mg/kg (más cardiotóxica).
- Síntomas neurológicos precoces: parestesias peribucales, sabor metálico, tinnitus, mareo, agitación, disartria, temblor, luego convulsiones y coma.
- Toxicidad cardiovascular: hipertensión y taquicardia iniciales, luego bradicardia, hipotensión, arritmias ventriculares y paro (especialmente con bupivacaína).
- Tratamiento inicial: detener la inyección, pedir ayuda, oxígeno y vía aérea, benzodiazepinas para convulsiones (midazolam), emulsión lipídica al 20% (bolo 1,5 ml/kg y luego infusión 0,25 ml/kg/min); RCP prolongada si paro (dosis menores de epinefrina, evitar lidocaína como antiarrítmico).
- Prevención: calcular dosis máxima por peso, aspirar antes de inyectar, inyectar lento y fraccionado, monitorizar. Seguimiento: derivar/trasladar a unidad con monitorización (UCI) tras estabilización.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Durante un bloqueo de nervio periférico con lidocaína para una cirugía de mano, el paciente refiere de pronto adormecimiento alrededor de los labios y un sabor metálico intenso en la boca. Segundos después presenta fasciculaciones faciales. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Continuar el bloqueo, ya que la dosis calculada era segura

B Suspender la inyección de inmediato y prepararse para tratar la toxicidad sistémica

C Administrar un antihistamínico, pensando en una reacción alérgica

D Completar la dosis y observar en las próximas 2 horas

E Solicitar una tomografía computarizada de cerebro de urgencia

Respuesta B. Sabor metálico, parestesias periorales y fasciculaciones son los pródromos clásicos de la toxicidad sistémica por anestésicos locales. Suspender la inyección de inmediato evita que progrese a convulsiones y colapso cardiovascular; esperar a completar la dosis es la conducta que más la agrava.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Durante un bloqueo peridural con bupivacaína para una cirugía ginecológica, la paciente refiere sabor metálico, mareos y tinnitus, y de inmediato presenta una convulsión tónico clónica generalizada, con colapso hemodinámico, bradicardia extrema y ensanchamiento del QRS. **¿Cuál es el tratamiento farmacológico específico que debe iniciarse de urgencia?**

A Infusión inmediata de emulsión lipídica al 20 %

B Bolo de 1 mg de adrenalina endovenosa directa

C Sulfato de magnesio en infusión rápida

D Flumazenil endovenoso en bolos seriados

E Amiodarona en bolo endovenoso

Respuesta A. El cuadro es una toxicidad sistémica grave por bupivacaína, probablemente por inyección intravascular inadvertida. El tratamiento específico es la emulsión lipídica al 20 %, en bolo de 1,5 mL por kilo en un minuto, seguida de infusión continua, que secuestra el anestésico libre en el plasma.

▶ VER CLASE 4.01.2.029 Septicemia

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.1 · Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sepsis: disfunción orgánica potencialmente mortal por respuesta desregulada a infección (aumento de SOFA ≥2). qSOFA (≥2: FR ≥22, PAS ≤100, alteración de conciencia) identifica riesgo fuera de UCI.
- Shock séptico: necesidad de vasopresores para PAM ≥65 mmHg y lactato >2 mmol/l pese a reposición adecuada de volumen.
- Buscar foco: neumonía, urinario, abdominal, piel y partes blandas, catéteres; hemocultivos (2 sets) y cultivos del foco antes de antibióticos, sin retrasarlos.
- Tratamiento inicial (primera hora): antibiótico de amplio espectro IV, cristaloides 30 ml/kg en hipotensión o lactato ≥4, medir lactato, vasopresor noradrenalina si PAM <65 pese a volumen; oxígeno, control del foco (drenaje).
- Seguimiento: derivar a UCI; reevaluar perfusión (llene capilar, diuresis, lactato) y ajustar antibióticos según cultivos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 72 años con pielonefritis aguda ingresa con T° 39 °C, FC 118 lpm, PA 78/40 mmHg y lactato de 4,5 mmol/L. Se toman hemocultivos, se inicia ceftriaxona y se administran 30 mL/kg de cristaloides en la primera hora. Persiste con presión arterial media de 55 mmHg. **¿Cuál es la siguiente medida más adecuada?**

A Nuevo bolo de 30 mL/kg de cristaloides

B Transfundir glóbulos rojos

C Iniciar dobutamina

D Administrar bicarbonato de sodio

E Iniciar noradrenalina para lograr presión arterial media de al menos 65 mmHg

Respuesta E. Hipotensión que persiste tras la reanimación con volumen y lactato elevado definen un shock séptico. El vasopresor de elección es la noradrenalina, titulada para mantener una presión arterial media de al menos 65 mmHg, idealmente por vía central (puede iniciarse por vía periférica). Insistir con grandes volúmenes aumenta el riesgo de sobrecarga.

▶ VER CLASE 4.01.2.030 Paro cardiorespiratorio

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 1.2 · Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico: paciente que no responde, sin respiración normal (o solo jadeo/gasping) y sin pulso palpable en 10 segundos. Activar sistema de emergencia y pedir DEA.
- RCP de alta calidad: compresiones 100-120/min, profundidad 5-6 cm, permitir reexpansión, minimizar interrupciones; relación 30:2 sin vía aérea avanzada; con vía aérea avanzada, compresiones continuas y 1 ventilación cada 6 s.
- Ritmos desfibrilables (FV/TV sin pulso): descarga precoz (bifásico 120-200 J), RCP 2 min; adrenalina 1 mg IV/IO tras la 3ª descarga y luego cada 3-5 min; amiodarona 300 mg tras la 3ª descarga y 150 mg tras la 5ª (o lidocaína).
- Ritmos no desfibrilables (asistolia, AESP): RCP + adrenalina 1 mg lo antes posible y cada 3-5 min; buscar causas reversibles 5H y 5T (hipovolemia, hipoxia, H+, hipo/hiperkalemia, hipotermia; neumotórax a tensión, taponamiento, tóxicos, trombosis pulmonar y coronaria).
- Post paro (retorno a circulación espontánea): ABC, SatO2 92-98%, PAM ≥65, ECG de 12 derivaciones (coronariografía si SDST), control de temperatura, glicemia. Seguimiento: derivar a UCI.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 65 años presenta un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario. Se inicia reanimación con compresiones de alta calidad y ventilación. Al conectar el monitor desfibrilador, el ritmo es una asistolia, confirmada en más de una derivación. **Además de mantener las compresiones, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Desfibrilar con 200 J bifásicos

B Administrar adrenalina 1 mg endovenosa lo antes posible y repetir cada 3 a 5 minutos

C Administrar amiodarona 300 mg endovenosa

D Cardioversión sincronizada

E Administrar atropina 1 mg endovenosa

Respuesta B. La asistolia es un ritmo no desfibrilable: el manejo es RCP de alta calidad, adrenalina 1 mg endovenosa o intraósea lo antes posible y cada 3 a 5 minutos, y búsqueda de causas reversibles (las 5H y 5T). La desfibrilación y la amiodarona son para fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso; la atropina ya no se recomienda.

▶ VER CLASE 4.01.2.031 Shock

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Shock: hipoperfusión tisular con disfunción celular; signos: hipotensión (PAS <90 o PAM <65), taquicardia, oliguria (<0,5 ml/kg/h), compromiso de conciencia, piel fría y llene capilar >2 s, lactato >2 mmol/l.
- Tipos: hipovolémico/hemorrágico (el más frecuente en trauma), distributivo (séptico, anafiláctico, neurogénico: piel caliente), cardiogénico (congestión, crepitaciones, ingurgitación yugular) y obstructivo (neumotórax a tensión, taponamiento, TEP).
- Diagnóstico específico: clínica + lactato, gases arteriales, hemograma, ECG, ecografía a pie de cama (RUSH/FAST) para diferenciar tipos.
- Tratamiento inicial: oxígeno, 2 vías venosas gruesas, cristaloides (1-2 L o 20-30 ml/kg) excepto en cardiogénico; hemorragia: control del sangrado y transfusión 1:1:1; séptico: antibióticos precoces + noradrenalina; anafiláctico: adrenalina 0,5 mg IM; obstructivo: descompresión/pericardiocentesis.
- Monitorizar con Foley (diuresis), PA y lactato seriado. Seguimiento: derivar a UCI o cirugía según la causa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 35 años, de 70 kg, ingresa tras un accidente de tránsito con fractura expuesta de fémur. Presenta FC 135 lpm, PA 80/50 mmHg, FR 32 por minuto, llene capilar enlentecido y está ansioso y confuso. Diuresis escasa por sonda. **Según la clasificación ATLS del shock hemorrágico, ¿qué clase presenta y cuál es su manejo?**

A Clase I; solo observación

B Clase II; cristaloides exclusivamente

C Clase III; reposición de volumen y transfusión de hemoderivados

D Clase I; vasopresores

E Clase II; noradrenalina

Respuesta C. Taquicardia sobre 120, hipotensión, taquipnea, confusión y oliguria corresponden a un shock hemorrágico clase III (pérdida de 30 a 40% de la volemia, aproximadamente 1.500 a 2.000 mL). Requiere control de la hemorragia, cristaloides tibios limitados y transfusión precoz de glóbulos rojos y hemoderivados. Los vasopresores no tienen rol en el shock hemorrágico inicial.

Conocimientos generales

18 códigos

▶ VER CLASE 4.01.3.001

Alimentación en enfermedades digestivas

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 4.2 · Pancreatitis Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Preferir siempre la vía enteral (oral o por sonda) sobre la parenteral: mantiene el trofismo intestinal, reduce infecciones y es más barata. Parenteral solo si el intestino no es funcional o no cubre requerimientos >7 días.
- Pancreatitis aguda: realimentación oral precoz cuando tolere (leve) y nutrición enteral por sonda nasogástrica o nasoyeyunal en grave; evitar ayuno prolongado.
- Pancreatitis crónica: dieta fraccionada, normograsa con enzimas pancreáticas en cada comida, suspender alcohol, suplementar vitaminas A, D, E, K.
- Cirrosis: no restringir proteínas (1,2-1,5 g/kg/día) incluso en encefalopatía; colación nocturna; restringir sodio (<2 g/día) si ascitis.
- Otras: enfermedad celíaca (dieta sin gluten de por vida: trigo, avena, cebada, centeno), diverticulosis y constipación (fibra 25-35 g/día), postoperatorio digestivo con realimentación precoz (protocolos ERAS).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 50 años cursa con una pancreatitis aguda grave de origen alcohólico. Al tercer día persiste con dolor, íleo leve e intolerancia a la vía oral; está hemodinámicamente estable. **¿Cuál es la forma de soporte nutricional más adecuada?**

A Nutrición enteral por sonda nasogástrica o nasoyeyunal

B Nutrición parenteral total como primera opción

C Ayuno prolongado hasta que normalice la amilasa

D Régimen oral completo hipergrasos

E Solo suero glucosado por 2 semanas

Respuesta A. En la pancreatitis aguda grave, la nutrición enteral precoz (por sonda nasogástrica o nasoyeyunal) es preferible a la parenteral: mantiene la barrera intestinal, reduce la translocación bacteriana, las infecciones y la mortalidad. La nutrición parenteral se reserva para cuando la vía enteral no es posible o es insuficiente; el ayuno prolongado no está indicado.

▶ VER CLASE 4.01.3.002

Antimicrobianos. Conceptos profilaxis y esquemas terapéuticos

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.17 · Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Profilaxis antibiótica quirúrgica: indicada en cirugía limpia-contaminada, contaminada y limpia con prótesis o alto riesgo; en sucia/infectada el antibiótico es tratamiento, no profilaxis.
- Fármaco habitual: cefazolina 2 g IV (3 g si >120 kg) dentro de los 60 minutos previos a la incisión; agregar metronidazol 500 mg en cirugía colorrectal/apendicular; clindamicina o vancomicina si alergia a betalactámicos.
- Redosificar si la cirugía dura más de 2 vidas medias (cefazolina cada 4 h) o sangrado >1.500 ml; no prolongar la profilaxis más de 24 h.
- Esquemas terapéuticos: infección intraabdominal comunitaria → ceftriaxona + metronidazol; grave o nosocomial → piperacilina-tazobactam o carbapenémico; piel y partes blandas → cefazolina/cloxacilina; pie diabético → amoxicilina-ácido clavulánico.
- Principios: tomar cultivos antes de iniciar, ajustar según resultado (desescalar), duración acotada (infección intraabdominal con foco controlado: ~4 días) y uso racional para evitar resistencia y C. difficile.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 11

Mujer de 35 años con dolor epigástrico recurrente. La ecografía muestra múltiples cálculos en la vesícula biliar. Se decide colecistectomía laparoscópica electiva. **¿Cuál esquema antibiótico es de elección como profilaxis de la herida operatoria?**

A Amoxicilina más ácido clavulánico
B Ceftriaxona
C Clindamicina
D Cloxacilina
E Cefazolina

Respuesta E. La cefazolina es el fármaco de elección para profilaxis quirúrgica en la colecistectomía electiva: cubre bien cocáceas grampositivas de piel y las enterobacterias que puede haber en la bilis, con un espectro más acotado y menor costo que otras opciones.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 11

Mujer de 35 años consulta por dolor abdominal epigástrico recurrente. La ecografía abdominal muestra múltiples cálculos en la vesícula biliar, y se decide realizar una colecistectomía laparoscópica electiva. **¿Cuál esquema antibiótico es de elección como profilaxis de infección de la herida operatoria?**

A Amoxicilina con ácido clavulánico
B Ceftriaxona
C Clindamicina
D Cloxacilina
E Cefazolina

Respuesta E. Toda cirugía limpia contaminada, como la colecistectomía electiva, requiere profilaxis antibiótica dirigida a cubrir cocáceas grampositivas y flora entérica. La cefazolina es el fármaco de elección en la mayoría de las cirugías abdominales, incluida esta.

▶ VER CLASE 4.01.3.003 Asepsia y antisepsia

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.17 · Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Asepsia: conjunto de medidas que impiden la llegada de microorganismos a un área (material estéril, técnica estéril, campo quirúrgico). Antisepsia: eliminación de microorganismos de piel y mucosas con antisépticos.
- Esterilización (elimina todas las formas incluidas esporas: autoclave a vapor, óxido de etileno, plasma de peróxido) vs desinfección de alto nivel (glutaraldehído, para endoscopios) vs limpieza.
- Antisépticos: clorhexidina alcohólica 2% (de elección para piel, efecto residual), povidona yodada, alcohol 70%. Clorhexidina acuosa en mucosas.
- Lavado quirúrgico de manos 3-5 minutos o fricción con solución alcohólica; higiene de manos en los 5 momentos de la OMS es la medida más eficaz contra IAAS.
- Preparación del paciente: ducha previa, no rasurar (si es necesario, cortar vello con máquina justo antes de la cirugía), pintar desde la incisión hacia la periferia; vestimenta estéril y circulación restringida en pabellón.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años será sometido a una hernioplastía inguinal electiva. Presenta abundante vello en la zona operatoria. **¿Cuál es la medida de preparación de la piel más adecuada para prevenir la infección de sitio quirúrgico?**

A Rasurado con navaja la noche anterior
B Rasurado con navaja en el pabellón
C No retirar el vello y pintar con povidona acuosa
D Si es necesario, cortar el vello con máquina eléctrica (clipper) inmediatamente antes de la cirugía y aplicar clorhexidina alcohólica
E Aplicar alcohol al 70% como único antiséptico, 24 horas antes

Respuesta D. El vello solo se retira si interfiere con la cirugía, y con máquina cortadora inmediatamente antes, porque el rasurado con navaja produce microlesiones que se colonizan y aumentan la infección de sitio quirúrgico, más aún si se hace la noche anterior. La antisepsia de elección es la clorhexidina en solución alcohólica.

▶ VER CLASE 4.01.3.004 Colostomías

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.3 · Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx

QUÉ HAY QUE SABER

- Colostomía: abocamiento del colon a la piel; puede ser terminal (Hartmann: tras resección con cierre del muñón rectal; o definitiva en amputación abdominoperineal) o en asa (derivación temporal).
- Indicaciones: perforación/peritonitis de colon (diverticulitis Hinchey III-IV), obstrucción por cáncer, trauma colónico, protección de anastomosis baja, cáncer de recto bajo.
- Características: deposiciones formadas en colostomía descendente/sigmoidea (menor riesgo de dermatitis); estoma normal rosado, húmedo y levemente protruido.

- Complicaciones: necrosis (estoma oscuro/negro), retracción, estenosis, prolapso, hernia paraestomal, dermatitis periestomal y obstrucción.
- Cuidados: bolsa de ostomía de tamaño adecuado, protección de la piel, educación al paciente y apoyo de enfermería especializada; reconstitución del tránsito (cierre) habitualmente a los 3-6 meses si fue temporal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 70 años con diverticulitis aguda Hinchey IV (peritonitis fecaloídea) es sometido a una cirugía de urgencia. Se realiza una sigmoidectomía, cierre del muñón rectal y abocamiento del colon descendente a la piel. **¿Cómo se denomina esta cirugía y qué tipo de ostomía se dejó?**

A Operación de Miles con colostomía definitiva

B Colostomía en asa sin resección

C Hemicolectomía derecha con ileostomía en asa

D Resección anterior baja con anastomosis primaria

E Operación de Hartmann con colostomía terminal

Respuesta E. La operación de Hartmann consiste en resecar el segmento enfermo, cerrar el muñón rectal y abocar el cabo proximal como colostomía terminal; es la técnica clásica en la peritonitis diverticular fecaloídea o en pacientes inestables. Se puede reconstruir el tránsito en un segundo tiempo. La operación de Miles reseca el recto y el ano, con colostomía definitiva.

▶ VER CLASE 4.01.3.005 Complicaciones postoperatorias frecuentes

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.16 · Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs)
Cirugía 11.17 · Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Fiebre postoperatoria por tiempos («5W»): 24-48 h atelectasia/respuesta inflamatoria; día 3-5 infección urinaria o neumonía, flebitis; día 5-7 infección de herida, filtración anastomótica o absceso; >7 días TVP/TEP, absceso, reacción a fármacos.
- Infección de herida operatoria: eritema, dolor, secreción purulenta (habitualmente día 5-7); tratamiento: abrir la herida, drenar y curar; antibióticos si celulitis o compromiso sistémico.
- Dehiscencia/evisceración: salida de líquido serohemático por la herida precede a la evisceración (día 5-8); cubrir con compresas húmedas estériles y pabellón.
- Íleo postoperatorio (habitual hasta 3-5 días): prolongado si alteraciones electrolíticas (hipokalemia), opioides, sepsis intraabdominal. Retención urinaria: Foley/cateterismo. Delirio en adulto mayor.
- Prevención: deambulación precoz, kinesioterapia respiratoria, tromboprofilaxis (HBPM o métodos mecánicos), profilaxis antibiótica adecuada, control glicémico, retiro precoz de sondas y catéteres.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 123

Paciente de 17 años, apendicectomizado hace 6 horas, evoluciona con malestar general y dolor abdominal intenso. Pulso regular de 120 por minuto, presión arterial de 90/50 mmHg y temperatura de 37,7 °C. Al examen abdominal hay dolor a la palpación profunda y superficial, con signos peritoneales difusos, mayores en el hemiabdomen inferior. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hemoperitoneo

B Evisceración

C Trombosis de la vena porta

D Dehiscencia de la base apendicular

E Tromboembolismo pulmonar masivo

Respuesta D. La dehiscencia de la base apendicular produce una peritonitis franca: dolor y signos peritoneales que empiezan localizados y se vuelven difusos, con fiebre y progresión a shock hipovolémico y séptico. Es mucho más frecuente que el hemoperitoneo, que se presenta primero con compromiso hemodinámico y palidez, y el dolor abdominal aparece después.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 173

Paciente de 46 años sometido a colecistectomía abierta. A las 48 horas presenta fiebre de 37,8 °C, eupneico, con frecuencia respiratoria de 14 por minuto y saturación de 98 por ciento. La herida está sin eritema ni secreción, y las vías venosas están permeables y sin signos inflamatorios. El examen pulmonar muestra crepitaciones localizadas en la base derecha. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Neumonía

B Dehiscencia de la anastomosis

C Atelectasia

D Infección de la herida operatoria

E Tromboembolismo pulmonar

Respuesta C. La atelectasia es la causa más frecuente de fiebre en las primeras 48 horas, y las crepitaciones localizadas la confirman. La neumonía necesitaría tos y expectoración mucopurulenta; el tromboembolismo suele tener taquicardia o inicio súbito; y la dehiscencia de la anastomosis da signos de peritonitis, no crepitaciones aisladas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 123

Un paciente de 17 años, apendicectomizado hace 6 horas, evoluciona con malestar general y dolor abdominal intenso. Su pulso es regular a 120 latidos por minuto, su presión arterial es 90/50 mmHg y su temperatura es 37,7 grados. En el examen abdominal presenta dolor a la palpación profunda y superficial, con signos peritoneales difusos, mayores en el hemiabdomen inferior. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hemoperitoneo
B Evisceración
C Trombosis de la vena porta
D Dehiscencia de la base apendicular
E Tromboembolismo pulmonar masivo

Respuesta D. Peritonitis difusa con taquicardia e hipotensión pocas horas después de una apendicectomía apunta a dehiscencia del muñón apendicular, complicación más frecuente que el hemoperitoneo. El hemoperitoneo da primero palidez y shock, con signos peritoneales tardíos. Requiere reanimación y reoperación.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 54 años, fumador, operado hace 20 horas de hemicolectomía izquierda por cáncer de colon. Presenta temperatura de 38,3 °C y frecuencia respiratoria de 22 por minuto. La herida está limpia, sin eritema ni secreción. Al examen pulmonar hay murmullo vesicular disminuido y crepitaciones finas en ambas bases. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar ceftriaxona endovenosa por sospecha de neumonía
B Indicar analgesia adecuada, espirometría incentivada y deambulación precoz
C Abrir la herida operatoria para descartar infección oculta
D Solicitar tomografía de tórax de urgencia
E Instalar catéter venoso central para monitorización

Respuesta B. Fiebre en las primeras 24 horas, herida limpia y crepitaciones bibasales: es el cuadro clásico de atelectasia pulmonar, favorecido por el tabaquismo. Se trata con analgesia, kinesiterapia respiratoria y movilización precoz, sin antibióticos ni estudio invasivo de la herida.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 11

Una paciente de 48 años, se somete a una gastrectomía total. Al segundo día postoperatoria presenta fiebre y taquicardia, con FC: 100x' y PA: 140/90. Al examen físico presenta herida operatoria sin alteraciones, con abdomen sensible a la palpación. El examen pulmonar muestra hipoventilación basal. ¿Cuál es la causa más probable de la fiebre?

A Infección urinaria
B Filtración de la anastomosis
C Reacción adversa a medicamentos
D Tromboembolismo pulmonar
E Atelectasia infectada

Respuesta E. La causa más frecuente de fiebre en las primeras 48 horas del posoperatorio es la atelectasia, y la hipoventilación basal en este cuadro la sugiere. La infección urinaria exige sonda y más días de evolución, y la filtración de anastomosis suele aparecer más tarde; el TEP y los fármacos son menos probables sin otros datos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 68

Un paciente se realiza una cirugía abdominal. Usted lo evalúa a las 24 horas y obser- va que la herida operatoria presenta abundante secreción serohemática, con depresión de la zona central. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Hernia umbilical
B Eventración
C Seroma
D Evisceración
E Infección de la herida operatoria

Respuesta C. Diagnóstico: Seroma (opción C). La descripción era muy pobre, pero seroma era lo más aceptable (aunque llevaba poco tiempo). La fiebre postquirúrgica es una complicación frecuente y potencialmente grave que requiere identificar su causa para tratarla adecuadamente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 40

Un paciente es sometido a una ccolecistectomía y a las 24 horas presenta fiebre hasta 38,3 grados celsius. Su examen físico muestra un paciente ferbil, con crepitaciones en la base pulmonar derecha, asociado a roncus. Tiene vías venosas in situ, sin eritema y su herida quirúrgica está cerrada, sin exudado ni eritema. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Tromboembolismo pulmonar
B Neumonía
C Atelectasia
D Infección de la herida operatoria
E Infección asociada a catéter

Respuesta C. Atelectasias son la primera causa de fiebre postoperatoria en las primeras 24 horas y la clínica es absolutamente concordante (crepitaciones localizadas, etc).

▶ VER CLASE 4.01.3.006 Concepto de paciente quirúrgico ambulatorio

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.14 · Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios

QUÉ HAY QUE SABER

- Cirugía mayor ambulatoria: procedimiento con alta el mismo día (o estadía <24 h) en pacientes seleccionados; reduce costos, IAAS y listas de espera.
- Criterios del paciente: ASA I-II (o III estable), con acompañante adulto responsable las primeras 24 h, domicilio cercano y accesible, comprensión de instrucciones.
- Criterios del procedimiento: duración limitada (idealmente <2 h), bajo riesgo de sangrado, dolor controlable con analgesia oral, sin necesidad de cuidados especiales (hernioplastía, colecistectomía laparoscópica, várices, cirugía anal, lesiones superficiales).
- Contraindicaciones: obesidad mórbida con apnea del sueño no tratada, ASA III-IV inestable, DM descompensada, falta de acompañante o red de apoyo.
- Criterios de alta (p. ej., escala de Aldrete modificada/PADSS): signos vitales estables, orientado, deambula, tolera vía oral, dolor y náuseas controlados, sin sangrado; instrucciones escritas y teléfono de contacto.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Se evalúan pacientes para colecistectomía laparoscópica en un programa de cirugía mayor ambulatoria. **¿Cuál de los siguientes pacientes NO es candidato a cirugía ambulatoria?**

A Mujer de 40 años, ASA I, que vive a 20 minutos del hospital con su pareja

B Hombre de 55 años, ASA II, hipertenso controlado, acompañado por su hijo

C Mujer de 70 años, ASA IV, con insuficiencia cardíaca descompensada, que vive sola

D Hombre de 35 años, ASA I, con índice de masa corporal de 28

E Mujer de 60 años, ASA II, con diabetes tipo 2 bien controlada, con cuidador en casa

Respuesta C. La cirugía mayor ambulatoria requiere un procedimiento de bajo riesgo, pacientes ASA I a II (o III estables), un adulto responsable que lo acompañe las primeras 24 horas y acceso rápido a un centro de salud. Un paciente ASA IV con enfermedad descompensada, que además vive solo, no cumple criterios.

▶ VER CLASE 4.01.3.007 Conceptos básicos de anestesia general, local y regional

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.15 · Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales

QUÉ HAY QUE SABER

- Anestesia general: hipnosis, analgesia, relajación muscular y protección neurovegetativa; inducción IV (propofol, opioide como fentanilo, relajante como rocuronio o succinilcolina) y mantención con halogenados (sevoflurano) o TIVA.
- Riesgos de anestesia general: aspiración (ayuno de 6 h sólidos y 2 h líquidos claros), hipertermia maligna (halogenados y succinilcolina; tratamiento dantroleno), vía aérea difícil, náuseas y vómitos postoperatorios.
- Anestesia regional neuroaxial: espinal (subaracnoidea, dosis pequeña, efecto rápido) y epidural (catéter, analgesia de parto y postoperatoria). Complicaciones: hipotensión, cefalea post punción (postural), hematoma epidural; contraindicada en coagulopatía, infección del sitio, hipovolemia no corregida.
- Anestesia local y bloqueos periféricos: lidocaína (inicio rápido, duración intermedia), bupivacaína (inicio lento, larga duración, más cardiotóxica); la epinefrina prolonga el efecto y reduce sangrado.
- Evaluación preanestésica: clasificación ASA (I sano a VI donante muerte cerebral; E urgencia), predictores de vía aérea difícil (Mallampati), medicamentos (anticoagulantes, antiagregantes) y alergias.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 28 años fue sometida a una cesárea bajo anestesia raquídea, sin incidentes, hace 48 horas. Al levantarse de la cama presenta cefalea holocraneana severa y dolor cervical, que empeora drásticamente al ponerse de pie y desaparece por completo en decúbito supino. El examen neurológico es normal. **¿Cuál es el diagnóstico y su mecanismo?**

A Meningitis bacteriana por inoculación intratecal

B Cefalea postpunción dural, por fuga persistente de líquido cefalorraquídeo

C Trombosis de senos durales por estado protrombótico puerperal

D Hemorragia subaracnoidea por rotura de aneurisma

E Cefalea tensional por contractura cervical

Respuesta B. El carácter estrictamente postural, con alivio completo en decúbito, es patognomónico de la cefalea postpunción dural: la fuga de líquido cefalorraquídeo por el orificio de la aguja espinal reduce la presión y produce tracción de estructuras sensibles al dolor.

▶ VER CLASE 4.01.3.008 Conceptos de manejo en situación de catástrofe (triage, extricación, inmovilización y transporte)

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Catástrofe o incidente con múltiples víctimas: la demanda supera la capacidad de respuesta; objetivo es hacer el mayor bien al mayor número de personas. Primero seguridad de la escena y del equipo.
- Triage START (adultos): camina → verde (diferido); no respira tras abrir vía aérea → negro (fallecido/expectante); FR >30, llene capilar >2 s o no obedece órdenes → rojo (inmediato); el resto → amarillo (urgente).
- Durante el triage solo se hacen maniobras salvadoras: abrir vía aérea y controlar hemorragia externa (compresión, torniquete). JumpSTART para niños.
- Extricación: rescate del paciente atrapado manteniendo alineación cervical (collar, chaleco de extricación tipo KED), por personal entrenado.
- Inmovilización y transporte: collar cervical, tabla espinal, movilización en bloque; trasladar al centro adecuado según gravedad (no al más cercano), con comunicación previa y registro.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En un accidente de bus con múltiples víctimas, usted aplica el triage START. Un paciente no puede caminar, respira espontáneamente con una frecuencia de 34 por minuto y tiene pulso radial palpable. **¿Qué categoría de triage le corresponde?**

A Verde (diferido, puede esperar)

B Amarillo (urgente, no inmediato)

C Negro (fallecido o expectante)

D Rojo (inmediato)

E Blanco (sin lesiones)

Respuesta D. En el triage START, quien camina es verde. En quien no camina se evalúa la respiración: si no respira tras abrir la vía aérea es negro; si respira con frecuencia mayor de 30 por minuto es rojo. Luego se evalúan la perfusión (llene capilar mayor de 2 segundos o sin pulso radial: rojo) y la obediencia a órdenes simples.

▶ VER CLASE 4.01.3.009 Conceptos generales de hipertensión portal

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.3 · Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipertensión portal: gradiente de presión venosa hepática >5 mmHg (clínicamente significativa ≥10 mmHg; riesgo de sangrado variceal ≥12). Causa principal en Chile: cirrosis (alcohol, NASH, virus).
- Clasificación: prehepática (trombosis portal), intrahepática (presinusoidal: esquistosomiasis; sinusoidal: cirrosis; postsinusoidal) y posthepática (Budd-Chiari, insuficiencia cardíaca derecha, pericarditis constrictiva).
- Manifestaciones: várices esofagogástricas, ascitis, esplenomegalia con trombocitopenia (hiperesplenismo), circulación colateral (cabeza de medusa), encefalopatía hepática.
- Prevención de sangrado: endoscopía de tamizaje en cirróticos; várices grandes → betabloqueador no selectivo (propranolol, carvedilol) o ligadura endoscópica.
- Hemorragia variceal: octreótido o terlipresina, ligadura endoscópica, ceftriaxona profiláctica; TIPS en refractarios. Ascitis: restricción de sodio, espironolactona ± furosemida, paracentesis evacuadora con albúmina.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años con ascitis de reciente aparición. Se realiza una paracentesis diagnóstica: albúmina en líquido ascítico 1,0 g/dL, con albúmina plasmática de 3,2 g/dL. Proteínas totales del líquido 1,5 g/dL y 100 células/mm3. **¿Qué indica el gradiente de albúmina sérica-ascítica de este paciente?**

A Ascitis por carcinomatosis peritoneal

B Ascitis por hipertensión portal

C Ascitis por tuberculosis peritoneal

D Ascitis pancreática

E Peritonitis bacteriana secundaria

Respuesta B. El gradiente de albúmina sérica-ascítica es 3,2 menos 1,0, es decir 2,2 g/dL. Un gradiente de 1,1 g/dL o más indica hipertensión portal (cirrosis, insuficiencia cardíaca, síndrome de Budd-Chiari); uno menor de 1,1 sugiere causas peritoneales como carcinomatosis, tuberculosis o pancreatitis. Las proteínas bajas orientan a cirrosis más que a causa cardíaca.

▶ VER CLASE 4.01.3.010 Conceptos generales del pre y post operatorio

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.14 · Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios

QUÉ HAY QUE SABER

- Preoperatorio: anamnesis y examen físico dirigidos (comorbilidades, fármacos, alergias, antecedentes anestésicos), clasificación ASA, riesgo cardiovascular (índice de Lee) y capacidad funcional (≥4 METs).
- Exámenes según edad, comorbilidad y tipo de cirugía (no rutinarios): hemograma, creatinina, electrolitos, glicemia, coagulación si anticoagulantes o hepatopatía, ECG en >45-50 años o cardiópatas, β-hCG en mujeres en edad fértil.
- Manejo de fármacos: suspender anticoagulantes (warfarina ~5 días con INR <1,5; ACOD 24-72 h según función renal y riesgo), clopidogrel 5-7 días si es posible; mantener betabloqueadores y estatinas; suspender metformina el día de la cirugía; ajustar insulina.
- Ayuno: 6 h sólidos, 2 h líquidos claros (protocolos ERAS permiten carga de carbohidratos). Profilaxis antibiótica y tromboprofilaxis según riesgo (Caprini).

- Postoperatorio: control de signos vitales, dolor (analgesia multimodal), balance hídrico y diuresis, deambulación y realimentación precoz, kinesioterapia respiratoria, vigilancia de herida y complicaciones.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años, con antecedente de infarto al miocardio hace 4 años y un stent coronario, hipertenso en tratamiento con enalapril y bisoprolol, será operado de una colecistectomía laparoscópica electiva. Camina 40 minutos diarios en subida sin angina ni disnea. Toma ácido acetilsalicílico 100 mg al día. **¿Cuál es la indicación más adecuada para el día de la cirugía?**

A Suspender el ácido acetilsalicílico y el bisoprolol por el riesgo de sangrado

B Mantener el bisoprolol y el ácido acetilsalicílico, y omitir el enalapril de esa mañana

C Suspender los tres fármacos 24 horas antes de la cirugía

D Solicitar evaluación cardiológica antes de definir cualquier fármaco

E Mantener los tres fármacos exactamente igual que todos los días

Respuesta B. Buena capacidad funcional: no necesita evaluación cardiológica adicional. El betabloqueador nunca se suspende. El ácido acetilsalicílico en prevención secundaria por stent se mantiene en cirugía general. El enalapril se suspende omitiendo solo la dosis de la mañana, para evitar hipotensión refractaria en la inducción.

▶ VER CLASE 4.01.3.011 Conceptos generales sobre injertos y colgajos

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.13 · Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Injerto: tejido trasladado sin su irrigación, depende de la imbibición e inosculación del lecho receptor; requiere lecho bien vascularizado (no prende sobre hueso sin periostio, tendón sin paratenon ni cartílago sin pericondrio).
- Injerto de piel parcial (epidermis + parte de dermis): prende más fácil, mayor contracción secundaria; útil en grandes superficies (quemados), puede mallarse. Total: mejor resultado estético y menos contracción; cara, manos.
- Causas de pérdida del injerto: hematoma o seroma bajo el injerto (la más frecuente), infección, movilización (cizallamiento), lecho mal vascularizado.
- Colgajo: tejido trasladado con su propia irrigación (pediculado o libre microquirúrgico); indicado en lechos pobres, exposición de estructuras nobles, defectos profundos. Locales (rotación, avance, transposición, Z-plastia) o a distancia.
- Escalera reconstructiva: cierre primario → cierre por segunda intención → injertos → colgajos locales → colgajos a distancia → colgajos libres; elegir la opción más simple que resuelva el defecto.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 40 años sufre un accidente con una máquina que le produce una pérdida de piel en el dorso del pie, con exposición del tendón extensor sin paratendón y de hueso sin periostio. El lecho está limpio tras el aseo quirúrgico. **¿Cuál es la opción de cobertura más adecuada?**

A Injerto de piel parcial

B Injerto de piel total

C Sustituto dérmico sin cobertura posterior

D Cierre por segunda intención con curaciones

E Colgajo

Respuesta E. Un injerto carece de irrigación propia y depende del lecho receptor para nutrirse, por lo que no prende sobre hueso sin periostio, tendón sin paratendón, cartílago sin pericondrio ni material de osteosíntesis expuesto. En esos casos se requiere un colgajo, que lleva su propio pedículo vascular. Los injertos son ideales sobre lechos bien vascularizados, como el tejido de granulación.

▶ VER CLASE 4.01.3.012 Diagnóstico precoz del cáncer mamario

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.14 · Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer de mama: más frecuente en mujeres chilenas; la detección precoz busca diagnosticar lesiones no palpables con mejor pronóstico.
- Mamografía de tamizaje: estrategia con evidencia de reducción de mortalidad; en Chile, examen de medicina preventiva (EMP) con mamografía en mujeres de 50 a 59 años cada 3 años (en la práctica también se usa 50-69 años cada 2 años).
- Examen físico de mamas por profesional en controles de salud; el autoexamen no ha demostrado reducir mortalidad pero promueve el conocimiento del propio cuerpo.
- Alto riesgo (BRCA, antecedente familiar fuerte, radioterapia torácica antes de los 30): tamizaje más precoz e intensivo (mamografía y RM anual desde ~30 años o 10 años antes del caso índice), consejería genética.
- BI-RADS: 0 incompleto (completar con eco/proyecciones), 1-2 benigno (control habitual), 3 probablemente benigno (control a 6 meses), 4-5 sospechoso/altamente sospechoso (biopsia), 6 cáncer confirmado; sospecha activa el GES.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 134

Mujer de 55 años se realiza una mamografía que es informada como BI-RADS 4, con microcalcificaciones agrupadas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Ecotomografía mamaria
B Biopsia estereotáxica
C Resonancia magnética
D Control mamográfico en 6 meses
E Mastectomía parcial

Respuesta B. BI-RADS 4 implica sospecha de malignidad y exige biopsia. Las microcalcificaciones agrupadas no palpables y habitualmente no visibles en ecografía se biopsian con guía estereotáxica (mamográfica), que permite el diagnóstico precoz de un carcinoma in situ o invasor. El control en 6 meses es la conducta del BI-RADS 3.

▶ VER CLASE 4.01.3.013 Epidemiología del cáncer.

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.5 · Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico

QUÉ HAY QUE SABER

- En Chile el cáncer es la primera causa de muerte en varias regiones, superando a las enfermedades cardiovasculares; su incidencia aumenta con el envejecimiento poblacional.
- Principales causas de muerte por cáncer: en hombres estómago, próstata y pulmón; en mujeres mama, vesícula, pulmón y colorrectal (colorrectal en aumento en ambos sexos).
- Particularidades chilenas: altas tasas de cáncer gástrico (H. pylori) y de vesícula (colelitiasis, mujeres del sur), cáncer pulmonar y de vejiga por arsénico en el norte.
- Factores modificables: tabaco (el principal), alcohol, obesidad, sedentarismo, dieta (sal, carnes procesadas, baja en fibra), infecciones (VPH, VHB, VHC, H. pylori), radiación solar.
- Prevención: primaria (vacuna VPH y VHB, cese tabáquico, estilo de vida saludable) y secundaria (PAP, mamografía, sangre oculta en deposiciones, endoscopía en grupos de riesgo); múltiples cánceres con garantías GES y Ley Nacional del Cáncer.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En una charla sobre epidemiología del cáncer en Chile, se analiza la mortalidad por tumores malignos en hombres. **¿Cuál es la primera causa de muerte por cáncer en hombres en Chile?**

A Cáncer gástrico
B Cáncer de próstata
C Cáncer de pulmón
D Cáncer colorrectal
E Cáncer de vesícula biliar

Respuesta A. En Chile, los tumores malignos son una de las principales causas de muerte, y en hombres el cáncer gástrico ocupa históricamente el primer lugar de mortalidad oncológica, seguido por próstata y pulmón. Por eso existe la garantía GES de endoscopía en mayores de 40 años con epigastralgia persistente, para diagnosticarlo precozmente.

▶ VER CLASE 4.01.3.014 Evaluación nutricional

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.14 · Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios

QUÉ HAY QUE SABER

- Desnutrición hospitalaria es frecuente y aumenta complicaciones (infección, dehiscencia, estadía); tamizar a todo paciente quirúrgico.
- Herramientas: IMC (<18,5 desnutrición), pérdida de peso involuntaria (>10% en 6 meses o >5% en 1 mes es significativa), Valoración Global Subjetiva, NRS-2002 y criterios GLIM.
- Laboratorio: albúmina (vida media ~20 días, refleja estado crónico y también inflamación; <3 g/dl mayor riesgo), prealbúmina (vida media 2 días, estado reciente), recuento de linfocitos, transferrina.
- Antropometría: pliegue tricipital (reserva grasa), circunferencia braquial y muscular del brazo (reserva proteica), dinamometría (fuerza).
- Requerimientos habituales: 25-30 kcal/kg/día y proteínas 1,2-1,5 g/kg/día (más en catabolismo, quemados); en desnutridos severos realimentar lento por riesgo de síndrome de realimentación (hipofosfemia, hipokalemia, hipomagnesemia).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 64 años con cáncer gástrico resecable, programado para gastrectomía. Ha bajado 12% de su peso en los últimos 6 meses, tiene un índice de masa corporal de 18 kg/m2 y albúmina plasmática de 2,8 g/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada desde el punto de vista nutricional?**

A Soporte nutricional preoperatorio, de preferencia enteral, por 7 a 14 días

B Operar de inmediato, porque el estado nutricional no influye en la evolución

C Postergar la cirugía 6 meses hasta normalizar la albúmina

D Solo suplementar vitaminas por vía oral

E Nutrición parenteral exclusiva por 3 meses

Respuesta A. Una baja de peso mayor de 10% en 6 meses, IMC menor de 18,5 y albúmina menor de 3 g/dL indican desnutrición grave, que aumenta las complicaciones postoperatorias (dehiscencias, infecciones). Está indicado un soporte nutricional preoperatorio de 7 a 14 días, preferentemente por vía enteral, sin retrasar en exceso una cirugía oncológica.

▶ VER CLASE 4.01.3.015 Ileostomías

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.4 · Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn

QUÉ HAY QUE SABER

- Ileostomía: abocamiento del íleon a la piel; terminal (tras colectomía total o proctocolectomía: colitis ulcerosa, poliposis) o en asa (protección temporal de anastomosis colorrectal baja o ileoanal).
- Débito líquido y rico en enzimas: alto riesgo de deshidratación, hiponatremia, hipokalemia e hipomagnesemia, y de dermatitis periestomal. Débito alto: >1,5-2 L/día.
- Estoma debe protruir ~2-3 cm (espiga de Brooke) para evitar contacto del efluente con la piel.
- Manejo del alto débito: soluciones de rehidratación oral (evitar líquidos hipotónicos en exceso), loperamida, dieta astringente, reponer electrolitos; mayor riesgo de litiasis renal (oxalato, úrica) y biliar.
- Complicaciones: necrosis, retracción, prolapso, hernia paraestomal, obstrucción (bolo alimentario). Cuidados por enfermería de ostomías y educación; cierre de ileostomía temporal en 2-3 meses tras verificar la anastomosis.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 32 años con colitis ulcerosa grave refractaria es sometida a colectomía total con ileostomía terminal. Al cuarto día postoperatorio, la ileostomía drena 2.000 mL al día. Presenta sed, mareos, sequedad de mucosas y creatinina que sube de 0,7 a 1,6 mg/dL. **¿Cuál es la complicación más probable?**

A Obstrucción intestinal por hernia paraestomal

B Deshidratación con insuficiencia renal aguda prerrenal por ileostomía de alto débito

C Necrosis del estoma

D Síndrome de intestino corto

E Infección de sitio quirúrgico

Respuesta B. Las ileostomías pierden agua y sodio, y un débito mayor de 1,5 a 2 L al día produce deshidratación, hiponatremia, hipokalemia e insuficiencia renal aguda prerrenal, la complicación metabólica precoz más frecuente. Se maneja con reposición hidroelectrolítica, soluciones de rehidratación oral, restricción de líquidos hipotónicos y antidiarreicos como loperamida.

▶ VER CLASE 4.01.3.016 Infección quirúrgica e intrahospitalaria

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.17 · Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS): ITU asociada a catéter urinario, neumonía asociada a ventilación mecánica, bacteriemia asociada a CVC, infección de herida operatoria y diarrea por C. difficile; vigilancia obligatoria en Chile (Programa Nacional de IAAS).
- Clasificación de heridas: limpia (I, ~2% infección: hernia), limpia-contaminada (II: apertura controlada de tubo digestivo/vía biliar), contaminada (III: herida traumática reciente, derrame de contenido), sucia (IV: pus, perforación, >6 h).
- Infección del sitio quirúrgico: incisional superficial, profunda o de órgano/espacio, dentro de 30 días (90 si hay prótesis). Factores: obesidad, DM, tabaco, desnutrición, cirugía prolongada, hipotermia.
- Prevención: higiene de manos, profilaxis antibiótica en el momento correcto, no rasurar, clorhexidina en piel, normotermia, control glicémico, técnica quirúrgica, retiro precoz de dispositivos invasivos, paquetes de medidas (bundles).
- Tratamiento de infección de herida: abrir y drenar, curaciones, cultivo; antibióticos si celulitis o compromiso sistémico. Aislamiento de contacto para gérmenes multirresistentes (SAMR, EPC, VRE).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 55 años, operada hace 5 días de una colectomía por laparotomía. Presenta fiebre de 38 grados y la herida operatoria muestra eritema, calor, induración y salida de pus entre los puntos, sin dehiscencia aponeurótica. Abdomen sin signos peritoneales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Abrir la herida retirando puntos, drenar, tomar cultivo y realizar curaciones

B Antibiótico oral y mantener los puntos

C Reoperar de urgencia por sospecha de filtración

D Aplicar compresas frías y observar

E Cerrar nuevamente la herida con puntos de refuerzo

Respuesta A. Es una infección superficial del sitio quirúrgico, típica entre el quinto y séptimo día. El tratamiento principal es abrir la herida, drenar, cultivar y curar, dejándola cerrar por segunda intención. Los antibióticos se agregan solo si hay celulitis extensa o compromiso sistémico significativo.

▶ VER CLASE 4.01.3.017 Manejo del dolor

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.15 · Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales

QUÉ HAY QUE SABER

- Evaluar el dolor con escalas (EVA o numérica 0-10; faciales en niños) y reevaluar periódicamente; distinguir nociceptivo somático, visceral y neuropático.
- Escalera analgésica OMS: leve → paracetamol (1 g c/6-8 h, máx 4 g/día) y/o AINE (ketoprofeno, diclofenaco, ibuprofeno); moderado → agregar opioide débil (tramadol 50-100 mg c/6-8 h, codeína); severo → opioide fuerte (morfina, fentanilo, metadona).
- Analgesia multimodal postoperatoria: combinar paracetamol, AINE, opioides y técnicas regionales (epidural, bloqueos, infiltración de la herida) para reducir dosis de opioides.
- Precauciones: AINE (úlcera, sangrado, falla renal, HTA, cardiopatía; preferir con IBP y evitar en ERC); opioides (constipación → laxante siempre; náuseas, sedación, depresión respiratoria → naloxona).
- Dolor neuropático: gabapentina, pregabalina, amitriptilina. Cuidados paliativos y alivio del dolor por cáncer avanzado es GES.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 55 años, en su primer día postoperatorio de una laparotomía por histerectomía, refiere dolor EVA 8/10 pese a paracetamol y ketorolaco endovenosos en horario. No tiene contraindicaciones ni alergias. **¿Cuál es la conducta analgésica más adecuada?**

A Mantener el mismo esquema y esperar que el dolor ceda

B Suspender todo y usar solo dipirona

C Agregar un segundo AINE

D Agregar un opioide, como morfina endovenosa titulada, manteniendo la analgesia multimodal

E Indicar diazepam para disminuir la ansiedad

Respuesta D. El dolor postoperatorio severo que no cede con analgesia no opioide requiere agregar un opioide (por ejemplo, morfina endovenosa titulada o en bomba de analgesia controlada por el paciente), manteniendo paracetamol y AINE como base multimodal para reducir la dosis de opioide. Combinar dos AINE no mejora la analgesia y aumenta la toxicidad.

▶ VER CLASE 4.01.3.018 Tratamiento antitetánico y antirrábico

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.18 · Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

QUÉ HAY QUE SABER

- Tétanos (C. tetani): heridas profundas, contaminadas con tierra, deposiciones o saliva, con tejido desvitalizado. Todas las heridas requieren aseo y desbridamiento.
- Esquema: herida limpia menor → toxoide (dT) solo si vacunación incompleta/desconocida o última dosis hace >10 años. Herida tetanígena → dT si última dosis >5 años, y agregar inmunoglobulina antitetánica 250-500 UI IM si vacunación incompleta o desconocida (en sitio distinto).
- Vacunación antitetánica: PNI con hexavalente (2, 4, 6 y 18 meses), refuerzos escolares (1° y 8° básico dTpa) y embarazadas (dTpa); adultos dT de refuerzo cada 10 años.
- Rabia: en Chile el reservorio principal es el murciélago; toda mordedura de mamífero exige aseo inmediato con agua y jabón abundante (15 min), evaluar el animal (observar perro/gato 10 días) y notificar.
- Profilaxis antirrábica post exposición: vacuna en días 0, 3, 7 y 14 (o según esquema MINSAL vigente) si contacto con murciélago, animal silvestre, animal no observable o que enferma; inmunoglobulina antirrábica en exposiciones graves (cabeza, cuello, manos, múltiples o murciélago).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 58 años sufre una herida cortante de 4 centímetros en la pierna izquierda con una lata oxidada, visiblemente sucia con tierra. Refiere esquema de vacunación al día, con la última dosis de refuerzo hace 7 años. **¿Cuál es la indicación correcta respecto a la profilaxis antitetánica?**

A No requiere ninguna intervención porque la última dosis fue hace menos de 10 años

B Administrar únicamente una dosis de refuerzo de vacuna antitetánica

C Administrar únicamente inmunoglobulina antitetánica

D Administrar vacuna e inmunoglobulina antitetánica simultáneamente

E Indicar penicilina benzatina en lugar de profilaxis antitetánica

Respuesta B. Con esquema completo previo y herida sucia, el corte para el refuerzo es de 5 años, no de 10. Como pasaron 7 años, corresponde una dosis de refuerzo de vacuna. No requiere inmunoglobulina, porque conserva memoria inmunológica que responde con el toxoide.

Exámenes e imagenología

15 códigos

▶ VER CLASE 4.01.4.001 **Radiografía de tórax** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.5 · Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)

QUÉ HAY QUE SABER

- Técnica: idealmente PA y lateral de pie en inspiración profunda; AP en decúbito en pacientes graves (agranda la silueta cardíaca). Verificar identificación, rotación (clavículas equidistantes de apófisis espinosas), inspiración (≥9-10 arcos costales posteriores) y penetración.
- Lectura sistemática: partes blandas y huesos (fracturas costales), mediastino (ensanchamiento >8 cm en trauma sugiere lesión aórtica), tráquea, silueta cardíaca (índice cardiotorácico >0,5 = cardiomegalia en PA), hilios, parénquima, pleura y diafragma.
- Neumoperitoneo: aire subdiafragmático en Rx de tórax de pie (perforación de víscera hueca); el examen más útil en abdomen agudo perforativo.
- Hallazgos clave: neumotórax (línea pleural sin trama vascular; a tensión con desviación mediastínica, pero se trata sin esperar Rx), derrame (borramiento del seno costofrénico, menisco), condensación con broncograma aéreo, atelectasia (pérdida de volumen), nódulo, cavidad con nivel.
- Verificar posición de dispositivos: tubo endotraqueal 3-5 cm sobre la carina, CVC en vena cava superior, SNG bajo el diafragma, tubo pleural.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 44 años, usuario crónico de diclofenaco por lumbago, consulta por dolor epigástrico de inicio súbito hace 3 horas, tipo puñalada, que se generalizó a todo el abdomen. Está pálido, sudoroso, con presión arterial de 100/60 y frecuencia cardíaca de 110. El abdomen no tiene movimiento respiratorio, está rígido en los cuatro cuadrantes, y a la percusión desaparece la matidez hepática. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Solicitar endoscopía digestiva alta de urgencia

B Solicitar radiografía de tórax de pie

C Indicar amilasa y lipasa seriadas

D Iniciar cefotaxima endovenosa y observar

E Solicitar colonoscopía de urgencia

Respuesta B. Dolor en puñalada, abdomen en tabla y signo de Jobert son el cuadro típico de una úlcera perforada. El examen inicial, por rapidez, es la radiografía de tórax de pie, buscando neumoperitoneo. La endoscopía está contraindicada, y la cefotaxima sola es el manejo de la peritonitis primaria, no de esta.

▶ VER CLASE 4.01.4.002 **Radiografía simple de abdomen** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.4 · Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

QUÉ HAY QUE SABER

- Proyecciones: decúbito (AP) y de pie (o decúbito lateral con rayo horizontal si no puede pararse) + Rx de tórax de pie para neumoperitoneo.
- Obstrucción de intestino delgado: asas centrales dilatadas (>3 cm) con válvulas conniventes que cruzan todo el diámetro («pila de monedas»), niveles hidroaéreos escalonados, poco gas en colon.
- Obstrucción de colon: asas periféricas dilatadas (>6 cm; ciego >9-12 cm riesgo de perforación) con haustras que no cruzan todo el lumen. Vólvulo de sigmoides: «grano de café» u «omega invertida»; vólvulo de ciego: asa dilatada en epigastrio/hipocondrio izquierdo.
- Otros hallazgos: neumoperitoneo, neumobilia (íleo biliar, tríada de Rigler: neumobilia, obstrucción, cálculo ectópico), calcificaciones (litiasis renal ~90% radioopaca, vesicular ~10-15%, pancreáticas en pancreatitis crónica), fecaloma, cuerpos extraños, borramiento del psoas.
- Limitaciones: baja sensibilidad en apendicitis, colecistitis, pancreatitis e isquemia; ante sospecha específica preferir ecografía o TAC.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 78 años, postrado y con constipación crónica, consulta por 2 días de distensión abdominal marcada, dolor cólico y ausencia de eliminación de gases. Está hemodinámicamente estable, sin signos peritoneales. La radiografía simple de abdomen muestra un asa colónica muy dilatada en forma de U invertida, que nace de la pelvis y se proyecta hacia el hipocondrio derecho, con aspecto de grano de café. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Vólvulo de sigmoides

B Obstrucción de intestino delgado por bridas

C Íleo biliar

D Megacolon tóxico

E Íleo paralítico

Respuesta A. El signo del grano de café, un asa sigmoidea gigante en U invertida que nace de la pelvis, es el hallazgo radiológico clásico del vólvulo de sigmoides, típico del adulto mayor postrado y constipado. Sin necrosis ni peritonitis se intenta primero la desvolvulación endoscópica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 39

Se muestra la siguiente radiografía: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Cáncer pulmonar

B Neumoperitoneo

C Signo de Chilaiditi

D Absceso pulmonar

E Quiste hidatídico

Respuesta B. foto clásica. El signo de Chilaiditi tiene el colon sobre el hígado, pero se ve con haustras y en la foto no se veían.

▶ VER CLASE 4.01.4.003 Radiografía de cráneo

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.12 · Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

QUÉ HAY QUE SABER

- Uso actual limitado: en TEC la TAC de cerebro sin contraste es el examen de elección (detecta hematomas, contusiones y fracturas); la Rx de cráneo no descarta lesión intracraneana.
- Proyecciones: AP, lateral y Towne (occipital); útil para fracturas lineales o deprimidas de bóveda cuando no hay TAC disponible, cuerpos extraños radioopacos y en sospecha de maltrato infantil (serie ósea).
- Informe: fractura lineal (riesgo de hematoma epidural si cruza surco de arteria meníngea media), fractura deprimida, neumoencéfalo, desplazamiento de glándula pineal calcificada.
- Lesiones líticas en «sacabocado» (mieloma múltiple), imagen en «sal y pimienta» (hiperparatiroidismo), silla turca agrandada (adenoma hipofisario).
- Ante TEC con Glasgow <15, pérdida de conciencia, amnesia, vómitos, focalidad, signos de fractura de base (ojos de mapache, Battle, oto/rinorraquia) o anticoagulación: solicitar TAC, no Rx.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 40 años sufre un golpe en la cabeza en una caída de escalera. Ingresa con Glasgow 13, cefalea intensa y 2 vómitos. No tiene déficit focal. **¿Cuál es el examen de imagen de elección?**

A Radiografía de cráneo AP y lateral

B Resonancia magnética de cerebro con gadolinio

C TAC de cerebro sin contraste

D Ecografía transfontanelar

E Observación sin imágenes

Respuesta C. En el traumatismo encéfalo-craneano con Glasgow menor de 15, vómitos repetidos o cefalea intensa, el examen de elección es la TAC de cerebro sin contraste, que detecta hematomas, contusiones y fracturas. La radiografía de cráneo tiene un rol muy limitado: una fractura no descarta ni confirma lesión intracraneana. La resonancia es más lenta y menos práctica en urgencia.

▶ VER CLASE 4.01.4.004 Radiografía de columna cervical

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación según reglas NEXUS o canadiense: no requiere imagen si está alerta, sin intoxicación, sin dolor en línea media, sin déficit neurológico ni lesión distractora (y rota el cuello 45° en canadiense).
- En trauma moderado-severo la TAC de columna cervical es el examen de elección; la Rx (lateral, AP y transoral para odontoides) se usa si no hay TAC o en bajo riesgo.
- La Rx lateral debe mostrar de C1 hasta la unión C7-T1 (tracción de hombros o proyección del nadador); una Rx incompleta no descarta lesión.

- Informe/lectura: alineación de las 4 líneas (vertebral anterior, posterior, espinolaminar, apófisis espinosas), altura de cuerpos vertebrales, espacio prevertebral aumentado (>7 mm en C2 o >21 mm en C6), espacio atlanto-odontoideo (>3 mm adulto), fracturas de Jefferson (C1), odontoides, ahorcado (C2).
- Mantener inmovilización cervical hasta descartar lesión clínica y radiológicamente; RM si déficit neurológico o sospecha de lesión ligamentosa con imagen normal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años, motociclista, ingresa con dolor cervical posterior tras un choque. Está inmovilizado con collar cervical. La radiografía lateral de columna cervical solo permite visualizar hasta el borde inferior de C6, sin lesiones evidentes. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Retirar el collar, porque la radiografía es normal

B Solicitar electromiografía

C Solicitar radiografía con proyecciones en flexión y extensión

D Mantener el collar y repetir la radiografía en 1 semana

E Solicitar TAC de columna cervical

Respuesta E. Una radiografía lateral cervical es adecuada solo si se visualizan las 7 vértebras cervicales y la unión C7-T1, sitio frecuente de lesiones. Si no se visualiza, se debe completar el estudio: actualmente la TAC de columna cervical es el examen de elección en el trauma. Las radiografías dinámicas están contraindicadas en el paciente agudo con dolor.

▶ VER CLASE 4.01.4.005 Radiografía de columna dorsal y lumbar

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.15 · Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones en trauma: dolor en línea media dorsal/lumbar, mecanismo de alta energía, caída de altura, déficit neurológico, fractura en otro nivel de columna. TAC de elección en politraumatizado.
- Lumbalgia mecánica sin banderas rojas no requiere imagen en las primeras 4-6 semanas.
- Banderas rojas que justifican estudio: >50 años o <20, antecedente de cáncer, baja de peso, fiebre, dolor nocturno, trauma significativo, osteoporosis/corticoides, déficit neurológico progresivo, síndrome de cauda equina (este último: RM urgente).
- Informe: fracturas por compresión/acuñamiento (osteoporosis: pérdida de altura anterior), estallido (compromiso de muro posterior, inestable), Chance (flexión-distracción por cinturón de seguridad, asociada a lesión de víscera hueca), espondilolistesis, lesiones líticas o blásticas (metástasis), escoliosis.
- La RM es el examen de elección para hernia discal con radiculopatía, compresión medular, infección (espondilodiscitis) o tumor.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 35 años, oficinista, consulta por dolor lumbar de 5 días tras levantar una caja. El dolor es mecánico, sin irradiación bajo la rodilla. No tiene fiebre, baja de peso, antecedentes de cáncer, trauma mayor ni alteraciones esfinterianas. El examen neurológico es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Radiografía de columna lumbar AP y lateral

B Resonancia magnética lumbar

C No solicitar imágenes; analgesia, mantener la actividad y control

D TAC de columna lumbar

E Reposo absoluto en cama por 2 semanas

Respuesta C. El lumbago agudo mecánico sin signos de alarma (edad mayor de 50 o menor de 20 años, cáncer, fiebre, baja de peso, trauma mayor, déficit neurológico o síntomas esfinterianos) no requiere imágenes, porque no cambian el manejo y suelen mostrar hallazgos inespecíficos. Se trata con analgesia y manteniendo la actividad; el reposo prolongado empeora la evolución.

▶ VER CLASE 4.01.4.006 Radiografía de pelvis y cadera

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.10 · Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía

QUÉ HAY QUE SABER

- Rx AP de pelvis es adjunto de la evaluación primaria en politraumatizado inestable: fractura de pelvis puede causar hemorragia masiva (retroperitoneal).
- Fracturas de pelvis: estables (rama única) vs inestables (anillo roto en ≥2 sitios, libro abierto, cizallamiento vertical). Manejo inicial en inestable: faja o sábana pelviana a nivel de trocánteres; no repetir maniobras de compresión.
- Fractura de cadera en adulto mayor (caída de baja energía): extremidad acortada y en rotación externa; Rx AP de pelvis y axial de cadera. Cuello (intracapsular, riesgo de necrosis avascular) vs intertrocantérica (extracapsular).
- Fractura de cadera en ≥65 años es GES (cirugía precoz idealmente en <48 h). Si Rx normal y alta sospecha: TAC o RM (fractura oculta).
- Otros hallazgos: luxación de cadera (posterior la más frecuente, reducir urgente por riesgo de necrosis), coxartrosis (disminución del espacio, osteofitos, esclerosis), displasia de cadera, Perthes y epifisiólisis en niños.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 82 años sufre una caída a nivel. Presenta dolor inguinal derecho e imposibilidad de caminar. La radiografía de pelvis AP y la axial de cadera derecha no muestran fractura, pero el dolor persiste al día siguiente e impide la marcha. **¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?**

A Repetir la radiografía en 3 semanas

B Ecografía de cadera

C Densitometría ósea

D Resonancia magnética de cadera

E Cintigrafía ósea en 1 mes

Respuesta D. Ante sospecha clínica de fractura de cadera con radiografías iniciales normales, el examen de elección es la resonancia magnética, que detecta fracturas ocultas del cuello femoral en las primeras horas (la TAC es alternativa si no hay acceso). Esperar semanas expone a desplazamiento de la fractura y necrosis avascular. La densitometría evalúa osteoporosis, no fracturas agudas.

▶ VER CLASE 4.01.4.007 Radiografía de extremidades

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.7 · Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince

QUÉ HAY QUE SABER

- Solicitar siempre al menos 2 proyecciones ortogonales (AP y lateral) e incluir las articulaciones proximal y distal al hueso lesionado.
- Reglas de Ottawa para tobillo y rodilla evitan radiografías innecesarias (p. ej., tobillo: dolor en maléolo posterior o incapacidad de apoyar 4 pasos).
- Informe de fractura: hueso y segmento, trazo (transverso, oblicuo, espiroideo, conminuto), desplazamiento, angulación, compromiso articular, expuesta o cerrada. En niños: fisis (Salter-Harris), fracturas en tallo verde y en rodete.
- Escafoides: dolor en tabaquera anatómica con Rx normal → inmovilizar y repetir Rx en 10-14 días o RM (riesgo de necrosis avascular).
- Otros hallazgos: luxaciones, cuerpos extraños radioopacos, gas en partes blandas (gangrena gaseosa), lesiones óseas líticas, osteomielitis (tardía). Fractura expuesta: antibióticos IV y profilaxis antitetánica urgentes, derivar a traumatología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 28 años sufre un esguince por inversión del tobillo derecho jugando básquetbol. Presenta dolor y edema en la zona lateral. No puede dar 4 pasos al llegar a urgencia y tiene dolor a la palpación del borde posterior del maléolo lateral. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar resonancia magnética de tobillo

B Solicitar radiografía de tobillo AP, lateral y mortaja

C Inmovilizar sin estudio radiológico

D Solicitar TAC de tobillo

E Solicitar radiografía de pie exclusivamente

Respuesta B. Según las reglas de Ottawa, se solicita radiografía de tobillo si hay dolor en la zona maleolar con dolor a la palpación del borde posterior o la punta de cualquiera de los maléolos, o incapacidad de dar 4 pasos. Esta paciente cumple ambos criterios. La radiografía de extremidades debe incluir al menos 2 proyecciones ortogonales.

▶ VER CLASE 4.01.4.008 Radiografías contrastadas (EED, trànsito intestinal, enema baritada y pielografía).

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.4 · Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico

QUÉ HAY QUE SABER

- Esofagograma (EED/esófago-estómago-duodeno): disfagia, acalasia («pico de pájaro»), divertículo de Zenker, anillos y membranas, estenosis, cáncer (imagen en «manzana mordida»), hernia hiatal.
- Sospecha de perforación o fístula: usar contraste hidrosoluble (bario produce mediastinitis/peritonitis química); en riesgo de aspiración, el contraste hidrosoluble hiperosmolar puede causar edema pulmonar.
- Tránsito intestinal: estenosis, Crohn (signo de la cuerda), tumores de intestino delgado; en gran medida reemplazado por enteroTAC/enteroRM.
- Enema baritado: Hirschsprung (zona de transición), diverticulosis, cáncer de colon («corazón de manzana»), vólvulo de sigmoides (pico de pájaro); reemplazado en su mayoría por colonoscopía y TAC. Contraindicado si sospecha de perforación o megacolon tóxico.
- Pielografía de eliminación (urografía excretora): reemplazada por uroTAC; contraindicada en alergia al medio de contraste yodado y falla renal (riesgo de nefropatía por contraste).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 60 años presenta dolor retroesternal intenso, fiebre y enfisema subcutáneo cervical pocas horas después de vómitos violentos tras una comida copiosa con alcohol. Se sospecha una perforación esofágica. **Si se decide realizar un estudio contrastado del esófago, ¿qué medio de contraste debe utilizarse inicialmente?**

A Bario, por su mejor definición de la mucosa

B No se usa contraste: basta una radiografía simple

C Aire, mediante endoscopía con insuflación

D Gadolinio

E Contraste hidrosoluble (yodado)

Respuesta E. Ante sospecha de perforación del tubo digestivo, el estudio contrastado debe hacerse con contraste hidrosoluble, porque el bario que escapa al mediastino o peritoneo produce una mediastinitis o peritonitis granulomatosa grave. Hoy la TAC con contraste oral hidrosoluble es el examen de elección en el síndrome de Boerhaave.

▶ VER CLASE 4.01.4.009 Mamografía

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.14 · Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizaje en mujeres asintomáticas (EMP 50-59 años cada 3 años en Chile) y diagnóstica ante nódulo, retracción, telorrea sanguinolenta o hallazgos al examen; en <35-40 años preferir ecografía (mama densa).
- Proyecciones estándar: cráneo-caudal y medio-lateral oblicua bilateral; complementarias con compresión focal o magnificación; ecografía complementa mamas densas y diferencia quiste de sólido.
- Hallazgos sospechosos: masa de bordes espiculados o irregulares, microcalcificaciones agrupadas, pleomórficas o lineales ramificadas, distorsión de la arquitectura, asimetría en desarrollo, retracción de piel o pezón.
- Informe BI-RADS: 0 incompleto, 1 negativo, 2 benigno, 3 probablemente benigno (control en 6 meses), 4 sospechoso (biopsia), 5 altamente sugerente de malignidad (biopsia), 6 malignidad comprobada.
- Conducta: BI-RADS 4-5 → derivar a patología mamaria para biopsia core/estereotáxica (activa garantías GES); una mamografía normal no descarta cáncer ante nódulo palpable sospechoso.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 179

Paciente con una lesión mamográfica clasificada como BI-RADS 3. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Biopsia core guiada por imagen

B Ecografía mamaria dirigida

C Resonancia magnética mamaria bilateral

D Mamografía de control en 6 meses

E Control en 1 año sin exámenes

Respuesta D. BI-RADS 3 significa hallazgo probablemente benigno, con riesgo de malignidad menor de 2%. Se maneja con seguimiento a corto plazo: mamografía de control a los 6 meses y luego periódicamente hasta completar 2 años de estabilidad. La biopsia se reserva para BI-RADS 4 y 5, o si la lesión cambia en el seguimiento.

▶ VER CLASE 4.01.4.010 TAC de tórax

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.4 · Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: nódulo pulmonar o masa en Rx, etapificación de cáncer, sospecha de TEP (angioTAC), trauma torácico grave (lesión aórtica, contusión pulmonar, neumotórax oculto), enfermedad intersticial (TAC de alta resolución), bronquiectasias, derrame complicado.
- AngioTAC: defecto de llenado en arterias pulmonares (TEP); requiere contraste yodado (cuidado con función renal y alergia).
- TAC de alta resolución: patrón en panal de abejas (fibrosis pulmonar idiopática), vidrio esmerilado, bronquiectasias (bronquio más ancho que su arteria, «anillo de sello»).
- Informe de nódulo: tamaño, densidad (sólido, subsólido, vidrio esmerilado), bordes, calcificación y crecimiento; seguimiento según guía Fleischner.
- Otros hallazgos: adenopatías mediastínicas, masas mediastínicas por compartimento, enfisema, cavidades, empiema loculado, neumomediastino (perforación esofágica).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años, en su décimo día postoperatorio de una artroplastía de cadera, presenta disnea súbita y dolor pleurítico. FC 110 lpm, PA 125/80 mmHg, SatO2 89% ambiental. Tiene edema de la pantorrilla izquierda. Su score de Wells indica alta probabilidad clínica. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A AngioTAC de tórax (angiografía pulmonar por TAC)

B Dímero D

C Radiografía de tórax

D TAC de tórax sin contraste

E Espirometría

Respuesta A. Con alta probabilidad clínica de tromboembolismo pulmonar en un paciente estable, se solicita directamente una angioTAC de tórax, examen de elección para confirmar el diagnóstico. El dímero D solo es útil para descartar en pacientes de probabilidad baja o intermedia. La TAC sin contraste no visualiza los trombos dentro de las arterias pulmonares.

▶ VER CLASE 4.01.4.011 Ecografía: distinguir vesícula y líquido intraabdominal

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.2 · Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap
Cirugía 11.11 · Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Ecografía abdominal: primera elección para patología biliar; sin radiación, disponible y repetible; limitada por gas intestinal y obesidad.
- Vesícula normal: estructura anecoica de pared fina (<3-4 mm). Colelitiasis: imagen hiperecogénica móvil con sombra acústica posterior; barro biliar sin sombra; pólipo: no móvil, sin sombra.
- Colecistitis aguda: pared engrosada >4 mm con doble halo, líquido perivesicular, vesícula distendida, Murphy ecográfico. Vía biliar dilatada (colédoco >6-7 mm; mayor en colecistectomizados y adultos mayores) sugiere obstrucción.
- Líquido libre intraabdominal: imagen anecoica en zonas declives (Morison, espacio esplenorrenal, fondo de saco de Douglas); en trauma (FAST) en paciente inestable indica hemoperitoneo y laparotomía.
- FAST evalúa 4 ventanas (pericardio, hepatorrenal, esplenorrenal, pelvis); eFAST agrega pleuras para neumotórax y hemotórax. Una FAST negativa no descarta lesión de víscera hueca ni retroperitoneal.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 62 años, cirrótico con ascitis, consulta por dolor en el hipocondrio derecho. En la ecografía se observan dos imágenes anecogénicas en esa región: una bajo el borde hepático y otra rodeando el hígado. **¿Qué hallazgo permite identificar cuál de ellas corresponde a la vesícula biliar y no a líquido libre?**

A Ser completamente anecogénica

B Ubicarse en el espacio hepatorrenal de Morrison

C Tener bordes angulados que se amoldan entre los órganos

D Desplazarse hacia las zonas declives al cambiar de posición al paciente

E Tener forma ovalada con pared propia bien definida, ubicada en el lecho vesicular y que puede contener cálculos o barro

Respuesta E. Ambos son anecogénicos. La vesícula es una estructura ovalada con pared propia, en su lecho bajo el hígado, y puede tener cálculos o barro. El líquido libre no tiene pared, forma ángulos agudos entre los órganos, se ubica en zonas declives como Morrison o la pelvis y se redistribuye con los cambios de posición.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años sufre un trauma abdominal cerrado por accidente de tránsito. Presión arterial 92/60, frecuencia cardíaca 118. En el Eco-FAST, en la ventana del hipocondrio derecho, se observa una banda anecogénica de bordes angulados entre el hígado y el riñón derecho; aparte, bajo el borde hepático, se ve una estructura ovalada anecogénica de pared fina y bien definida. **¿Cuál es la interpretación correcta?**

A La banda entre hígado y riñón es líquido libre en el espacio de Morrison, y la estructura ovalada es la vesícula

B Ambas imágenes corresponden a la vesícula biliar normal

C La banda corresponde a un quiste renal simple

D La estructura ovalada corresponde a hemoperitoneo

E Ambas imágenes son artefactos sin significado clínico

Respuesta A. El líquido libre no tiene pared propia, forma ángulos que se amoldan entre los órganos y se acumula en zonas declives como el espacio de Morrison. La vesícula es ovalada, con pared propia y está en su lecho bajo el hígado. En un paciente inestable, un FAST positivo indica laparotomía.

▶ VER CLASE 4.01.4.012 Hemograma, perfil bioquímico, pefil hepático.

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Gastroenterología 3.1 · Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemograma: anemia (VCM bajo ferropénica, alto por B12/folato o alcohol), leucocitosis con desviación izquierda (infección bacteriana), leucopenia, plaquetas (trombocitopenia en hiperesplenismo/cirrosis, CID). Hemoglobina inicial puede ser normal en hemorragia aguda.

- Perfil bioquímico: glicemia, función renal (creatinina, BUN; BUN/creatinina >20 sugiere HDA o deshidratación), electrolitos, calcio, ácido úrico, proteínas totales y albúmina (estado nutricional y síntesis hepática).
- Patrón hepatocelular: transaminasas muy elevadas (>10 veces en hepatitis viral, tóxica, isquémica; AST/ALT >2 sugiere alcohol). Patrón colestásico: FA y GGT elevadas con bilirrubina directa (obstrucción biliar).
- Función de síntesis hepática: albúmina baja y TP prolongado (no corrige con vitamina K en daño hepático; sí corrige en colestasia por malabsorción de vitamina K).
- Bilirrubina indirecta aislada elevada: hemólisis (con LDH alta, haptoglobina baja, reticulocitos altos) o síndrome de Gilbert (aumenta con ayuno o estrés). Lipasa/amilasa >3 veces: pancreatitis.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 52 años consulta por ictericia y prurito. Exámenes: bilirrubina total 6,2 mg/dL (directa 5,0), fosfatasa alcalina 680 U/L (VN hasta 120), GGT 520 U/L, GOT 85 U/L y GPT 95 U/L. Hemograma normal. **¿Cuál es el patrón de laboratorio y el siguiente examen más adecuado?**

A Patrón hepatocelular; serología de hepatitis viral

B Hemólisis; test de Coombs directo

C Patrón colestásico; ecografía abdominal

D Síndrome de Gilbert; ningún examen adicional

E Patrón hepatocelular; biopsia hepática

Respuesta C. Predominio de bilirrubina directa con fosfatasa alcalina y GGT muy elevadas, y transaminasas solo levemente aumentadas, configura un patrón colestásico. El primer examen es la ecografía abdominal, que distingue colestasia extrahepática (vía biliar dilatada) de intrahepática. En la hemólisis y el síndrome de Gilbert predomina la bilirrubina indirecta.

▶ VER CLASE 4.01.4.013 Pruebas de coagulación

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.11 · Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno

QUÉ HAY QUE SABER

- Tiempo de protrombina (TP/INR): vía extrínseca (factor VII) y común; prolongado en uso de warfarina (meta INR 2-3), déficit de vitamina K, daño hepático y CID.
- TTPA: vía intrínseca (VIII, IX, XI, XII) y común; prolongado con heparina no fraccionada (monitoreo), hemofilias A y B, anticoagulante lúpico (no corrige con mezcla), Von Willebrand severa.
- Recuento de plaquetas (<50.000 riesgo de sangrado quirúrgico, <10-20.000 sangrado espontáneo) y fibrinógeno (bajo en CID, transfusión masiva). Tiempo de sangría casi en desuso; disfunción plaquetaria por AAS/clopidogrel no altera TP ni TTPA.
- CID: TP y TTPA prolongados, plaquetas y fibrinógeno bajos, dímero D muy elevado, esquistocitos. HBPM y ACOD no se monitorizan con TTPA (anti-Xa si se requiere).
- Antes de cirugía: estudiar coagulación si historia de sangrado, hepatopatía, anticoagulación o desnutrición; procedimientos invasivos suelen requerir INR <1,5 y plaquetas >50.000. Reversión: vitamina K, plasma o complejo protrombínico (warfarina), protamina (heparina).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 60 años hospitalizado por una trombosis venosa profunda inicia tratamiento con heparina no fraccionada en infusión endovenosa continua. **¿Qué examen de laboratorio se utiliza para monitorizar la dosis de este fármaco?**

A Tiempo de protrombina expresado como INR

B Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA)

C Recuento de plaquetas exclusivamente

D Tiempo de sangría

E Dímero D

Respuesta B. La heparina no fraccionada potencia la antitrombina e inhibe principalmente la vía intrínseca y común; su efecto se monitoriza con el TTPA, buscando 1,5 a 2,5 veces el valor control (o niveles anti-Xa). El INR controla los antagonistas de vitamina K. El recuento de plaquetas se vigila por riesgo de trombocitopenia inducida por heparina.

▶ VER CLASE 4.01.4.014 Gases arteriales y electrolitos plasmáticos

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 3.3 · Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia

QUÉ HAY QUE SABER

- Valores normales: pH 7,35-7,45, PaCO2 35-45 mmHg, HCO3 22-26 mEq/l, PaO2 80-100 mmHg (respirando aire); PaO2/FiO2 <300 indica falla respiratoria (SDRA según grado).
- Análisis sistemático: pH (acidemia/alcalemia) → trastorno primario (PaCO2 respiratorio, HCO3 metabólico) → compensación esperada (acidosis metabólica: PaCO2 esperada = 1,5 × HCO3 + 8 ± 2, fórmula de Winter).
- Acidosis metabólica: calcular anión gap = Na − (Cl + HCO3) (normal 8-12). AG aumentado: cetoacidosis, láctica (shock, isquemia), insuficiencia renal, tóxicos (metanol, etilenglicol, salicilatos); AG normal: diarrea, fístulas pancreáticas/ileostomía, acidosis tubular renal.

- Alcalosis metabólica: vómitos o SNG con pérdida de HCl (hipoclorémica e hipokalémica), diuréticos; se corrige con suero fisiológico y potasio. Acidosis respiratoria: hipoventilación (EPOC, sedación); alcalosis respiratoria: ansiedad, TEP, sepsis precoz.
- Electrolitos: hiponatremia (corregir no más de 8-10 mEq/l en 24 h: mielinolisis), hiperkalemia (ECG con T picudas → gluconato de calcio, insulina + glucosa, salbutamol), hipokalemia (íleo, arritmias; reponer KCl), hipercalcemia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años con diabetes tipo 1 ingresa con vómitos y respiración profunda. Gases arteriales: pH 7,20; pCO2 26 mmHg; HCO3 10 mEq/L. Electrolitos: Na 138 mEq/L, Cl 100 mEq/L, K 5,2 mEq/L. **¿Cuál es la interpretación correcta?**

A Acidosis metabólica con anión gap normal

B Acidosis metabólica con acidosis respiratoria agregada

C Acidosis respiratoria aguda

D Alcalosis metabólica con acidosis respiratoria

E Acidosis metabólica con anión gap aumentado y compensación respiratoria adecuada

Respuesta E. pH bajo con bicarbonato bajo indica acidosis metabólica. El anión gap es 138 menos (100 más 10), es decir 28, aumentado (normal alrededor de 12), compatible con cetoacidosis. La pCO2 esperada según Winter es 1,5 por 10 más 8, es decir 23 más o menos 2; 26 está en el límite, por lo que la compensación respiratoria se considera adecuada.

▶ VER CLASE 4.01.4.015 TAC de abdomen y pelvis

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA

Cirugía 11.3 · Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx
Cirugía 11.4 · Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

QUÉ HAY QUE SABER

- TAC de abdomen y pelvis con contraste IV: examen de mayor rendimiento en abdomen agudo del adulto (apendicitis, diverticulitis complicada, obstrucción, perforación, isquemia, pancreatitis grave), trauma abdominal en paciente estable y etapificación oncológica.
- Antes del contraste yodado: evaluar función renal (riesgo de nefropatía por contraste; hidratar), alergia previa (premedicación), metformina (suspender en falla renal), embarazo (preferir ecografía o RM).
- Hallazgos a reconocer en el informe: apéndice >6 mm con alteración de grasa, absceso, aire libre, zona de transición en obstrucción, neumatosis intestinal/gas portal (isquemia), necrosis pancreática, colecciones.
- Trauma: laceraciones de hígado/bazo con grado de lesión, hemoperitoneo, sangrado activo (blush de contraste), lesión renal; paciente inestable no va a TAC.
- AngioTAC para isquemia mesentérica y aneurisma aórtico; uroTAC sin contraste para litiasis urinaria (el más sensible); TAC trifásico para tumores hepáticos y pancreáticos.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 68 años consulta por 3 días de dolor progresivo en la fosa ilíaca izquierda, con fiebre de 38 grados y constipación. Al examen: resistencia muscular localizada en esa zona, sin masa palpable. Leucocitos 14.800. **¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?**

A Colonoscopía para visualizar directamente el colon

B TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso

C Enema baritado para evaluar los divertículos

D Radiografía simple de abdomen de pie

E Ecografía transvaginal para descartar causa ginecológica

Respuesta B. Cuadro clásico de diverticulitis aguda: dolor progresivo en FII con fiebre y leucocitosis en una adulta mayor. El TAC de abdomen y pelvis con contraste es el examen de elección para confirmar el diagnóstico y etapificar según Hinchey. La colonoscopía y el enema baritado están contraindicados en la fase aguda por riesgo de perforación.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 74 años, sin cirugías abdominales previas, consulta por 24 horas de dolor cólico, vómitos y detención del tránsito de gases. Está estable, afebril, sin hernias palpables. La radiografía simple de abdomen muestra asas de intestino delgado dilatadas con niveles hidroaéreos. **¿Cuál es el examen más útil para definir la causa de la obstrucción y buscar signos de sufrimiento intestinal?**

A Tránsito intestinal con bario

B Colonoscopía

C TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso

D Ecografía abdominal

E Repetir la radiografía simple en 24 horas

Respuesta C. Sin cirugía previa las bridas son poco probables, por lo que hay que buscar otra causa. La TAC con contraste muestra el punto de transición, la causa, como tumor, hernia interna o íleo biliar, y signos de isquemia o perforación. El bario está contraindicado ante sospecha de perforación.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

32 códigos

▶ VER CLASE 4.01.5.001 Anestesia local por infiltración

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.15 · Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: sutura de heridas, drenaje de abscesos, extirpación de lesiones superficiales. Lidocaína 1-2% (inicio 2-5 min, duración 1-2 h; con epinefrina 2-4 h).
- Dosis máxima de lidocaína: 4,5 mg/kg (máx 300 mg) sin epinefrina y 7 mg/kg (máx 500 mg) con epinefrina; 1% = 10 mg/ml (en 70 kg sin epinefrina ≈ 30 ml de lidocaína al 1%).
- Técnica: asepsia, aguja fina (25-27 G), inyectar lento a través de los bordes de la herida (menos doloroso), aspirar antes de inyectar para evitar vía intravascular; esperar el efecto antes de manipular.
- Epinefrina reduce sangrado y prolonga el efecto; históricamente evitada en dedos, pene, nariz y orejas (actualmente se considera segura en dedos con circulación normal, pero precaución en vasculopatía).
- Reconocer toxicidad (parestesias peribucales, sabor metálico, tinnitus, convulsiones, arritmias): suspender, oxígeno, benzodiazepinas y emulsión lipídica 20%. Bicarbonato en la solución reduce el dolor de la infiltración.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 60 kg con una herida cortante de 6 cm en el antebrazo, que requiere sutura. Se usará lidocaína al 1% sin epinefrina para anestesia local por infiltración. Recuerde que la solución al 1% contiene 10 mg por mL. **¿Cuál es el volumen máximo aproximado que se puede infiltrar?**

A 5 mL
B 10 mL
C 100 mL
D 60 mL
E 27 mL

Respuesta E. La dosis máxima de lidocaína sin epinefrina es de 4,5 mg/kg, con techo de 300 mg. En 60 kg son 270 mg, que al 1% equivalen a 27 mL. Al infiltrar se aspira antes de inyectar para evitar inyección intravascular, y se vigilan pródromos de toxicidad como sabor metálico o parestesias peribucales.

▶ VER CLASE 4.01.5.002 Anestesia troncular de dedos y ortejos

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.15 · Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales

QUÉ HAY QUE SABER

- Bloqueo digital (troncular) de dedos y ortejos: bloquea los 4 nervios digitales (2 dorsales y 2 palmares/plantares) en la base del dedo; indicado en onicectomía, heridas y drenaje de panadizos.
- Técnica clásica: inyectar lidocaína 1-2% sin epinefrina (2-3 ml por lado) en ambas caras laterales de la base del dedo, desde dorsal hacia palmar/plantar; volumen total máximo ~6-8 ml para no comprimir los vasos.
- Evitar anestésico con epinefrina en pacientes con vasculopatía periférica, Raynaud o diabetes con mala perfusión; no usar torniquete prolongado.
- Complicaciones: isquemia digital por volumen excesivo o compresión, lesión neurovascular, inyección intravascular, infección.
- Nivel del perfil: conocer la técnica y sus indicaciones; derivar a especialista cuando el procedimiento no puede realizarse con seguridad o hay compromiso vascular previo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años requiere sutura de una herida en el pulpejo del dedo índice. Se decide realizar una anestesia troncular digital con lidocaína. **¿Cuál es la técnica correcta?**

A Infiltrar directamente en el pulpejo, alrededor de la herida
B Infiltrar solo en la cara dorsal de la falange distal
C Infiltrar en la muñeca a nivel del nervio radial exclusivamente
D Infiltrar en la base del dedo, en ambas caras laterales (dorsolateral y palmar-lateral), donde transcurren los nervios digitales
E Infiltrar en forma circular completa con gran volumen, como un anillo apretado

Respuesta D. La anestesia troncular digital bloquea los 4 nervios colaterales (2 dorsales y 2 palmares), que corren por las caras laterales del dedo: se infiltra en la base del dedo, a ambos lados. Se usan volúmenes pequeños, porque los anillos de gran volumen comprimen las arterias digitales; tradicionalmente se recomienda lidocaína sin vasoconstrictor.

▶ VER CLASE 4.01.5.003 Anoscopía

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.7 · Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: rectorragia, dolor anal, prolapso, prurito, sospecha de hemorroides internas, fisura, condilomas intraanales, abscesos y fístulas (orificio interno), lesiones sospechosas de cáncer anal.
- Preparación: explicar el procedimiento, posición de Sims (decúbito lateral izquierdo con rodillas flectadas) o genupectoral; enema evacuante opcional; buena iluminación.
- Técnica: inspección anal separando glúteos, tacto rectal previo, introducir anoscopio lubricado con obturador hacia el ombligo, retirar obturador y evaluar mucosa al retirar lentamente en los distintos cuadrantes.
- Hallazgos: hemorroides internas (sobre línea pectínea, grado según prolapso), papilas hipertróficas, fisura, orificios fistulosos, condilomas, pólipos y tumores (biopsiar o derivar).
- Contraindicaciones relativas: fisura anal aguda muy dolorosa (diferir o anestesia tópica), absceso perianal agudo doloroso, estenosis anal. En >50 años con rectorragia complementar con colonoscopía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 32 años consulta por rectorragia de sangre roja fresca, que gotea al final de la defecación, indolora, de 2 semanas de evolución. Sin baja de peso ni antecedentes familiares de cáncer de colon. El tacto rectal es normal. **¿Cuál es el examen inicial más adecuado?**

A Anoscopía

B Colonoscopía total urgente

C TAC de abdomen y pelvis

D Enema baritado

E Cintigrafía con glóbulos rojos marcados

Respuesta A. En un adulto joven con rectorragia indolora de sangre roja que gotea al final de la deposición, la causa más probable son las hemorroides internas, que no se palpan en el tacto rectal. La anoscopía es el examen inicial que permite visualizarlas. Si no se encuentra la causa o hay signos de alarma, se complementa con colonoscopía.

▶ VER CLASE 4.01.5.004 Ayudantía quirúrgica (nociones básicas)

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.17 · Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Nociones básicas: lavado quirúrgico de manos, vestimenta estéril (bata y guantes con técnica cerrada), respetar el campo estéril y la zona estéril (adelante, entre cintura y hombros).
- Funciones del ayudante: exposición del campo con separadores, aspiración y secado, tracción y contratracción, corte de suturas, hemostasia con pinzas y ligaduras, anticipar los tiempos quirúrgicos.
- Instrumental básico: bisturí (hojas 10, 11, 15), tijeras Metzenbaum (tejidos) y Mayo (suturas), pinzas con y sin dientes, Kelly y Kocher, porta agujas, separadores (Farabeuf, Richardson).
- Suturas: absorbibles (catgut, poliglactina/Vicryl, PDS) para planos profundos y no absorbibles (nylon, seda, polipropileno) para piel y vasos; nudos cuadrados seguros.
- Seguridad: pausa de seguridad (lista de verificación quirúrgica OMS), recuento de compresas e instrumental, manejo seguro de cortopunzantes (no reencapuchar).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un interno se prepara para participar como ayudante en una laparotomía. Ya realizó el lavado quirúrgico de manos y se colocó delantal y guantes estériles. **¿Cuál de las siguientes zonas de su delantal se considera estéril durante la cirugía?**

A La parte anterior desde el tórax hasta la cintura y las mangas hasta 5 cm sobre el codo

B La espalda completa

C Todo el delantal, incluyendo bajo la cintura

D Solo los hombros y el cuello

E Ninguna zona, solo los guantes

Respuesta A. Por convención, en el delantal quirúrgico solo se considera estéril la cara anterior desde el tórax hasta el nivel de la mesa (cintura) y las mangas desde los puños hasta unos 5 cm sobre el codo. La espalda, los hombros, el cuello y lo bajo la cintura no son estériles; por eso las manos se mantienen frente al tórax.

▶ VER CLASE 4.01.5.005 Instalación y cuidado de sonda Foley

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.2 · Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: retención urinaria aguda, monitoreo de diuresis en paciente grave/shock/quemado, cirugía prolongada, incontinencia con lesiones sacras, irrigación vesical por hematuria con coágulos.
- Contraindicación absoluta: sospecha de lesión uretral (sangre en meato, hematoma perineal o escrotal, próstata alta o no palpable en trauma pélvico) → uretrografía y eventual cistostomía.

- Técnica estéril: aseo genital, lubricante con lidocaína, sonda 14-16 Fr en adulto; en hombre traccionar el pene hacia arriba (90°); avanzar hasta salida de orina y luego insertar unos centímetros más antes de inflar el balón (10 ml de agua destilada) para no dañar la uretra.
- En retención urinaria con gran volumen el vaciamiento puede ser completo (la descompresión rápida es segura; vigilar hematuria ex vacuo y diuresis postobstructiva). Reposicionar el prepucio para evitar parafimosis.
- Cuidados: sistema cerrado, bolsa bajo el nivel de la vejiga, fijación al muslo, aseo genital diario, retiro lo antes posible (principal factor de ITU asociada a catéter). No tratar bacteriuria asintomática.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 70 años con retención urinaria aguda requiere la instalación de una sonda Foley. Se realiza técnica aséptica con lubricante con lidocaína. **¿En qué momento debe inflarse el balón de la sonda?**

A Apenas la punta de la sonda pasa el meato

B Al sentir resistencia en la uretra prostática, sin esperar salida de orina

C Antes de introducir la sonda, para comprobar el balón dentro de la uretra

D Después de observar salida de orina y avanzar la sonda hasta su bifurcación

E Solo si el paciente refiere dolor

Respuesta D. El balón debe inflarse solo cuando se confirma que está en la vejiga: tras ver salir orina, se avanza la sonda hasta la bifurcación y luego se infla con agua destilada. Inflarlo en la uretra produce dolor, sangrado y lesión uretral (falsa vía). Ante resistencia que no cede o sangre en el meato, no se debe forzar.

▶ VER CLASE 4.01.5.006 Colonoscopía

NIVEL **DERIVAR A ESPECIALISTA**

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.5 · Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: tamizaje de cáncer colorrectal (≥50 años o FIT positivo; antecedente familiar desde 40), rectorragia, anemia ferropénica, cambio del hábito intestinal, vigilancia post polipectomía o cáncer, EII.
- Ventajas: diagnóstica y terapéutica (biopsia, polipectomía, hemostasia, dilatación, devolvulación de sigmoides, tatuaje de lesiones).
- Preparación intestinal (polietilenglicol) indispensable; dieta sin residuos previa; ajustar anticoagulantes/antiagregantes, hierro y hipoglicemiantes; sedación habitual.
- Contraindicaciones: perforación sospechada, peritonitis, diverticulitis aguda (esperar 6-8 semanas), megacolon tóxico, inestabilidad hemodinámica.
- Complicaciones: perforación (~1/1000; más con polipectomía), sangrado post polipectomía, complicaciones de la sedación. Nivel del perfil: indicar y derivar al especialista e interpretar el informe.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 55 años, asintomático, se realiza un test inmunoquímico de sangre oculta en deposiciones como tamizaje de cáncer colorrectal, que resulta positivo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Repetir el test en 1 año

B Colonoscopía completa

C Rectosigmoidoscopía flexible exclusiva

D TAC de abdomen y pelvis

E Antígeno carcinoembrionario

Respuesta B. Un test de sangre oculta positivo en el tamizaje de cáncer colorrectal obliga a realizar una colonoscopía completa, que permite visualizar todo el colon, tomar biopsias y resecar pólipos en el mismo procedimiento. La rectosigmoidoscopía no evalúa el colon proximal, y el antígeno carcinoembrionario no sirve para diagnóstico ni tamizaje.

▶ VER CLASE 4.01.5.007 Cricoidostomía

NIVEL **REALIZAR**

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Cricotiroidotomía (cricoidostomía) quirúrgica de urgencia: vía aérea quirúrgica de elección en la situación «no puedo intubar, no puedo oxigenar» (trauma facial grave, edema de glotis, cuerpo extraño no extraíble).
- Reparos: membrana cricotiroidea, entre cartílago tiroides (arriba) y cricoides (abajo), en línea media; extender el cuello si no hay sospecha de lesión cervical (si la hay, mantener alineación).
- Técnica: estabilizar laringe con la mano no dominante, incisión vertical de piel (2-3 cm) e incisión transversa de la membrana, dilatar con mango del bisturí o pinza, introducir cánula/tubo nº 5-6 con balón, inflar, ventilar y confirmar con capnografía.
- Cricotiroidotomía por punción con aguja (14 G) y ventilación jet: de elección en niños <12 años (la quirúrgica está contraindicada por riesgo de estenosis subglótica); es transitoria (30-45 min).
- Complicaciones: sangrado, falsa vía, lesión laríngea o esofágica, enfisema subcutáneo, estenosis subglótica tardía. Convertir a traqueostomía formal en 24-72 h.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 7 años, víctima de un accidente de tránsito con trauma facial grave, presenta obstrucción de la vía aérea con desaturación progresiva. Fracasan la intubación orotraqueal y la ventilación con bolsa-mascarilla. **¿Cuál es el procedimiento de rescate de la vía aérea más adecuado?**

A Cricotiroidotomía quirúrgica

B Traqueostomía reglada en pabellón

C Cricotiroidotomía por punción con aguja y ventilación en jet

D Intubación nasotraqueal a ciegas

E Esperar al anestesiólogo manteniendo oxígeno por mascarilla

Respuesta C. Ante un escenario de no intubable y no oxigenable, se requiere una vía aérea quirúrgica. En menores de 12 años la cricotiroidotomía quirúrgica está relativamente contraindicada por riesgo de estenosis subglótica, y se prefiere la punción cricotiroidea con aguja y ventilación en jet. La intubación nasal está contraindicada en trauma facial grave.

▶ VER CLASE 4.01.5.008 Curación básica de quemaduras

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.13 · Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Quemaduras tributarias de manejo ambulatorio: superficiales (A o AB superficial) de poca extensión (<10% en adultos, <5% en niños) sin zonas especiales ni lesiones asociadas.
- Primera atención: retirar la fuente y la ropa, enfriar con agua corriente tibia/fría (no hielo) por 10-20 min, analgesia (paracetamol, AINE, opioide si es necesario) y profilaxis antitetánica.
- Curación: aseo con suero fisiológico o agua y jabón neutro, retirar tejido desvitalizado y flictenas rotas (las flictenas pequeñas e íntegras pueden dejarse), cubrir con apósito no adherente (gasa vaselinada, tull) ± sulfadiazina de plata 1% o apósitos bioactivos; vendaje.
- Frecuencia: curar cada 24-72 h según apósito y exudado; vigilar signos de infección (eritema perilesional, aumento de dolor, secreción, fiebre) y profundización.
- Derivar si no epiteliza en 10-14 días (sugiere quemadura profunda → injerto), quemadura en zona especial, circunferencial, eléctrica, química, en niños pequeños o adultos mayores, o sospecha de maltrato. Fotoprotección y lubricación de la piel nueva.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 35 años se quema el antebrazo con agua hirviendo hace 2 horas. Presenta una quemadura de espesor parcial superficial, rosada, húmeda y dolorosa, con flictenas rotas, que compromete cerca del 3% de la superficie corporal. No tiene otras lesiones. **¿Cuál es el manejo local más adecuado?**

A Aplicar hielo directo y dejar la herida descubierta

B Lavar con suero fisiológico, retirar las flictenas rotas, cubrir con apósito no adherente y controlar en 48 a 72 horas

C Aplicar pomada de corticoides y vendaje compresivo

D Iniciar antibiótico oral profiláctico y dejar las flictenas intactas sin cubrir

E Derivar de inmediato a un centro de grandes quemados

Respuesta B. La curación básica de una quemadura pequeña de espesor parcial consiste en enfriar con agua o suero a temperatura ambiente, lavar con suero, retirar el tejido desvitalizado y las flictenas rotas, y cubrir con apósito no adherente, con controles cada 48 a 72 horas. No se usan antibióticos profilácticos ni hielo.

▶ VER CLASE 4.01.5.009 Curación de heridas, sutura y aseo

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.18 · Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

QUÉ HAY QUE SABER

- Evaluación previa: mecanismo y tiempo de evolución, contaminación, compromiso de tendones, nervios y vasos (examen neurovascular distal antes de anestesiar), cuerpos extraños; profilaxis antitetánica.
- Aseo: irrigación abundante con suero fisiológico a presión, desbridamiento del tejido desvitalizado, hemostasia; anestesia local con lidocaína (máx 4,5 mg/kg sin epinefrina).
- Sutura: cierre primario si <6-8 h (cara hasta 24 h) y herida limpia; mordeduras y heridas muy contaminadas en extremidades: cierre diferido o segunda intención. Puntos simples o colchonero; monofilamento no absorbible para piel (nylon 3-0/4-0 tronco y extremidades, 5-0/6-0 cara) y absorbible en planos profundos.
- Retiro de puntos: cara 5 días, cuero cabelludo 7-10, tronco y extremidades superiores 10, extremidades inferiores 10-14, sobre articulaciones 14.
- Cuidados: mantener seca 24-48 h, control a las 48 h, signos de infección (eritema, calor, secreción, fiebre) → retirar puntos y drenar. Antibiótico profiláctico solo en mordeduras, heridas muy contaminadas o inmunosuprimidos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 25 años con una herida cortante limpia de 2 cm en la mejilla, producida hace 2 horas, que se sutura con puntos simples de material no absorbible fino. **¿En cuántos días se deben retirar los puntos?**

A Entre 5 y 7 días

B Entre 10 y 12 días

C Entre 14 y 21 días

D A los 30 días

E No se retiran porque se reabsorben

Respuesta A. En la cara, por su excelente irrigación, los puntos se retiran a los 5 a 7 días, lo que evita las marcas de los puntos. El cuero cabelludo se retira a los 7 a 10 días, el tronco y las extremidades entre 10 y 14, y sobre articulaciones hasta 14 días. El material no absorbible sí debe retirarse.

▶ VER CLASE 4.01.5.010 Denudación venosa

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Denudación venosa: acceso venoso quirúrgico (disección de una vena periférica para canularla bajo visión directa) cuando no es posible acceso percutáneo periférico, central o intraóseo.
- Sitios habituales: vena safena interna en el tobillo (anterior y superior al maléolo medial), vena basílica en el pliegue del codo.
- Hoy en gran parte reemplazada por la vía intraósea (rápida, segura, útil en adultos y niños en paro o shock) y por catéteres centrales guiados por ecografía.
- Complicaciones: infección, flebitis, hematoma, lesión del nervio safeno o de arteria acompañante, trombosis.
- Nivel del perfil: conocer indicaciones y alternativas, derivar al especialista; en emergencia con acceso periférico imposible, preferir vía intraósea.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 40 años en shock hemorrágico tras un politraumatismo. No ha sido posible canalizar dos vías venosas periféricas y no se dispone de dispositivo intraóseo. Se decide realizar una denudación venosa. **¿Cuál es el sitio clásico de elección para este procedimiento en el adulto?**

A Vena yugular externa

B Vena cefálica en el surco deltopectoral

C Vena femoral en el triángulo de Scarpa

D Vena subclavia

E Vena safena interna, anterior al maléolo medial

Respuesta E. La denudación venosa es una técnica de acceso vascular de rescate cuando fracasan las vías periféricas y la vía intraósea. El sitio clásico es la vena safena interna en el tobillo, aproximadamente 2 cm anterior y superior al maléolo medial, por su ubicación constante y superficial. Hoy se prefiere la vía intraósea o central, más rápidas.

▶ VER CLASE 4.01.5.011 Drenaje de lesiones superficiales

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.8 · Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: abscesos cutáneos y subcutáneos, forúnculos y ántrax fluctuantes, quiste epidérmico infectado, absceso pilonidal, paroniquia y panadizo, hematoma subungueal (trepanación).
- Técnica: asepsia, anestesia local (infiltración en anillo alrededor; menos eficaz en tejido inflamado), incisión siguiendo líneas de tensión de la piel sobre el punto de máxima fluctuación, suficientemente amplia.
- Evacuar pus, romper tabiques con pinza o dedo, irrigar con suero fisiológico, tomar cultivo si es recurrente o hay compromiso sistémico; dejar mecha o drenaje y no cerrar la herida.
- Antibióticos solo si celulitis extensa, compromiso sistémico, inmunosupresión, diabetes, zona facial (triángulo peligroso) o mano: cefadroxilo o flucloxacilina; clindamicina o cotrimoxazol si SAMR.
- Derivar a cirugía: abscesos profundos (perianal profundo, mano con compromiso de vainas, cuello, mama extensa), fascitis necrotizante, sepsis. Curaciones cada 24-48 h hasta cierre por segunda intención.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años, sano, consulta por una lesión dolorosa en el glúteo de 5 días. Al examen presenta un nódulo de 3 cm, eritematoso, caliente y fluctuante, sin celulitis extensa. Está afebril y sin compromiso del estado general. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Antibióticos orales exclusivos por 10 días

B Incisión y drenaje, con aseo de la cavidad

C Compresas tibias y control en 1 semana

D Punción con aguja fina y alta

E Resección en bloque del nódulo

Respuesta B. Un absceso cutáneo fluctuante se trata con incisión y drenaje amplio, rompiendo tabiques y aseando la cavidad. En abscesos simples, sin celulitis extensa, fiebre ni inmunosupresión, el drenaje suele ser suficiente; los antibióticos solos no penetran adecuadamente la colección. La punción simple tiene alta recurrencia.

▶ VER CLASE 4.01.5.012 Endoscopía digestiva alta

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.2 · Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: dispepsia con signos de alarma (baja de peso, disfagia, anemia, vómitos persistentes, hemorragia) o ≥40 años en Chile (GES cáncer gástrico), HDA (en <24 h), ingesta de cáusticos o cuerpo extraño, sospecha de várices, ERGE refractaria, Barrett, celíaca (biopsias duodenales).
- Terapéutica: hemostasia (inyección de adrenalina, clips, termocoagulación), ligadura de várices, extracción de cuerpos extraños, dilatación de estenosis, gastrostomía percutánea, resección de lesiones precoces.
- Permite biopsias y test de ureasa para H. pylori (suspender IBP 2 semanas y antibióticos 4 semanas antes para evitar falsos negativos).
- Preparación: ayuno de 6-8 h, ajustar anticoagulantes, sedación consciente; consentimiento informado. Contraindicaciones: perforación sospechada, inestabilidad no corregida, falta de cooperación.
- Complicaciones: perforación, sangrado, aspiración, eventos por sedación. Nivel del perfil: indicar oportunamente, derivar al especialista e interpretar el informe (clasificación de Forrest en úlceras, Los Ángeles en esofagitis).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 48 años consulta por epigastralgia de 1 mes de evolución, sin respuesta a medidas generales. No tiene baja de peso, anemia ni vómitos. No usa antiinflamatorios. **¿Cuál es la conducta más adecuada según la guía GES de cáncer gástrico?**

A Endoscopía digestiva alta con test de ureasa

B Tratamiento empírico con omeprazol por 3 meses sin estudio

C Ecografía abdominal

D Serología para Helicobacter pylori y tratamiento si es positiva

E Radiografía esófago-estómago-duodeno con bario

Respuesta A. En Chile, por la alta incidencia de cáncer gástrico, la guía GES indica endoscopía digestiva alta en personas de 40 años o más con epigastralgia de más de 15 días, aun sin síntomas de alarma, con biopsias y test de ureasa. Probar y tratar Helicobacter pylori sin endoscopía se reserva para menores de 40 años sin signos de alarma.

▶ VER CLASE 4.01.5.013 Evaluación pre y post-operatoria

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.14 · Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios

QUÉ HAY QUE SABER

- Evaluación preoperatoria: anamnesis (comorbilidades, fármacos, alergias, hábitos, antecedentes anestésicos y hemorrágicos), examen físico dirigido, clasificación ASA y capacidad funcional.
- Riesgo cardiovascular: índice de Lee (cirugía de alto riesgo, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, DM con insulina, creatinina >2 mg/dl); capacidad funcional <4 METs con alto riesgo → evaluación cardiológica.
- Exámenes dirigidos según edad, comorbilidad y cirugía; manejo de anticoagulantes, antiagregantes e hipoglicemiantes; optimizar HTA, DM, anemia y estado nutricional; dejar de fumar.
- Evaluación postoperatoria: signos vitales, dolor, diuresis, herida, drenajes, tolerancia oral, deambulación; detectar precozmente complicaciones (fiebre, sangrado, íleo, retención urinaria, delirio, TVP).
- Nivel del perfil: el médico general hace la evaluación básica y deriva al especialista (anestesiología, cardiología, cirugía) a pacientes de alto riesgo o con comorbilidad descompensada.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 62 años, hipertenso en tratamiento crónico con enalapril y amlodipino, y con cardiopatía coronaria en tratamiento con bisoprolol y atorvastatina, será sometido a una hernioplastia inguinal electiva. **¿Cuál es la indicación más apropiada para el día de la intervención?**

A Suspender todos los antihipertensivos y coronarios 48 horas antes

B Suspender el enalapril 24 horas antes y mantener bisoprolol y atorvastatina la mañana de la cirugía

C Suspender el bisoprolol 24 horas antes y administrar el enalapril esa mañana

D Mantener todos los fármacos sin excepción, con un sorbo de agua

E Reemplazar todos los fármacos orales por infusión de nitroprusiato

Respuesta B. El enalapril se suspende 24 horas antes, omitiendo la dosis de la mañana, para prevenir hipotensión refractaria. El bisoprolol y la atorvastatina nunca se suspenden bruscamente: se administran esa misma mañana, con un sorbo de agua.

▶ VER CLASE 4.01.5.014 Evaluación primaria en trauma

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Evaluación primaria ATLS (XABCDE): identificar y tratar simultáneamente lesiones que amenazan la vida en los primeros minutos. X: control de hemorragia exanguinante externa (compresión, torniquete).
- A: vía aérea con restricción de movimiento de columna cervical (tracción mandibular, cánula, intubación o vía aérea quirúrgica si Glasgow ≤8 o vía aérea comprometida). B: ventilación (buscar y tratar neumotórax a tensión, abierto, hemotórax masivo, tórax volante).
- C: circulación con control de hemorragia (2 vías venosas gruesas, cristaloides tibios 1 L, transfusión precoz, ácido tranexámico, faja pelviana); identificar fuente: tórax, abdomen, pelvis, huesos largos, externa.
- D: déficit neurológico (Glasgow, pupilas, lateralización; glicemia). E: exposición completa con prevención de hipotermia (mantas, fluidos tibios).
- Adjuntos: monitoreo ECG, oximetría, capnografía, gases, Foley y SNG (si no hay contraindicación), Rx de tórax y pelvis, eFAST. Reevaluar ante cualquier deterioro; decidir traslado precoz si se requieren recursos mayores.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años, motociclista, llega tras una colisión de alta energía. Presenta ronquido y respiración ruidosa, Glasgow 8, presión arterial 90/60 y frecuencia cardíaca 120. Tiene deformidad del muslo derecho, sin sangrado externo activo. **¿Cuál es la primera acción que se debe realizar?**

A Instalar dos vías venosas gruesas e iniciar cristaloides

B Permeabilizar y asegurar la vía aérea con restricción de movimiento de la columna cervical

C Solicitar TAC de cerebro

D Alinear e inmovilizar la fractura de fémur

E Solicitar radiografía de pelvis

Respuesta B. La evaluación primaria sigue el orden ABCDE: primero vía aérea con protección cervical. El ronquido y el Glasgow 8 indican una vía aérea comprometida, que mata antes que la hipovolemia. Recién después se evalúa ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición.

▶ VER CLASE 4.01.5.015 Evaluación secundaria en trauma

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Se inicia solo cuando la evaluación primaria está completa, el paciente responde a la reanimación y sus signos vitales se normalizan.
- Historia AMPLE: alergias, medicamentos, patologías previas/embarazo (pregnancy), última comida (lunch), eventos/entorno del trauma (mecanismo).
- Examen físico de cabeza a pies: cráneo y cara, columna cervical, tórax, abdomen, periné/recto/vagina (sangre en meato, próstata alta), musculoesquelético (deformidades, pulsos, síndrome compartimental), examen neurológico completo y dorso (giro en bloque).
- Estudios complementarios dirigidos: TAC (cerebro, columna, tórax, abdomen), Rx de extremidades, eventual uretrografía, angiografía.
- Reevaluación continua: ante deterioro volver al ABCDE; documentar hallazgos y considerar la evaluación terciaria (lesiones inadvertidas en 24 h). Profilaxis antitetánica y analgesia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 40 años cae desde 4 metros. Se completa la evaluación primaria: vía aérea permeable, ventilación normal, presión arterial 120/80 tras 1 litro de cristaloides, Glasgow 15 y sin lesiones evidentes a la exposición. Se mantiene estable. **¿Cuál es el paso siguiente más adecuado?**

A Realizar la evaluación secundaria: anamnesis dirigida y examen físico completo de cabeza a pies, incluido el dorso

B Dar de alta con analgesia y control en 48 horas

C Realizar laparotomía exploradora

D Repetir solo la evaluación primaria cada 5 minutos sin otro examen

E Iniciar la evaluación secundaria antes de terminar la evaluación primaria

Respuesta A. La evaluación secundaria comienza solo cuando la primaria está completa y el paciente estabilizado. Incluye anamnesis dirigida, con alergias, medicamentos, antecedentes, última comida y mecanismo, y un examen de cabeza a pies, incluido el dorso con rotación en bloque, para pesquisar lesiones no evidentes.

▶ VER CLASE 4.01.5.016 Fibrobroncoscopía

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.8 · Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Fibrobroncoscopía: endoscopía de la vía aérea con broncoscopio flexible, diagnóstica y terapéutica.
- Indicaciones diagnósticas: sospecha de cáncer pulmonar (biopsia, cepillado, lavado), hemoptisis (localizar sangrado), atelectasia persistente, neumonía que no resuelve, TBC con baciloscopías negativas (lavado broncoalveolar), enfermedad intersticial, estridor.
- Terapéuticas: extracción de cuerpo extraño (en niños de elección la broncoscopía rígida), aspiración de secreciones o tapones mucosos, intubación difícil guiada, manejo de hemoptisis, stents.
- Contraindicaciones/riesgos: hipoxemia severa no corregida, inestabilidad hemodinámica, coagulopatía (para biopsias), IAM reciente; complicaciones: hipoxemia, broncoespasmo, sangrado, neumotórax (biopsia transbronquial).
- Nivel del perfil: indicar y derivar a broncopulmonar; interpretar el informe. Ante sospecha de cuerpo extraño en niño (tos súbita, sibilancias unilaterales, atrapamiento aéreo) derivar urgente.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 64

Niño de 3 años presenta tos súbita, sibilancias unilaterales y disminución del murmullo pulmonar en el hemitórax derecho. Los padres refieren que estaba comiendo maní. La radiografía de tórax muestra hiperinsuflación derecha. **¿Cuál es el tratamiento definitivo?**

A Broncoscopía virtual por TAC

B Broncoscopía rígida con extracción del cuerpo extraño

C Espirometría

D TAC de tórax y observación

E Antibióticos y kinesioterapia

Respuesta B. Tos súbita mientras comía maní, con sibilancias y murmullo disminuidos unilaterales e hiperinsuflación (efecto valvular), indica cuerpo extraño bronquial. El tratamiento definitivo es la broncoscopía rígida bajo anestesia general, que permite ventilar y extraer el objeto. La fibrobroncoscopía flexible es útil para diagnóstico; la broncoscopía virtual no es terapéutica.

▶ VER CLASE 4.01.5.017 Hemostasia con ligaduras y taponamiento de heridas sangrantes

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.18 · Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

QUÉ HAY QUE SABER

- Primera medida en toda hemorragia externa: compresión directa firme y sostenida sobre la herida con gasas (no retirar las empapadas, agregar encima) y elevación de la extremidad.
- Taponamiento (packing) de heridas profundas o cavitarias (inguinal, axilar, cervical) con gasas, idealmente hemostáticas, seguido de compresión.
- Torniquete en hemorragia de extremidad que no cede con compresión: colocar 5-7 cm proximal a la herida (no sobre articulación), apretar hasta que cese el sangrado y desaparezca el pulso distal, anotar la hora; tolerancia ~2 h.
- Ligadura: pinzar solo vasos visualizados (no pinzar a ciegas por riesgo de dañar nervios), ligar con sutura absorbible; electrocoagulación en vasos pequeños. Agentes tópicos: adrenalina en anestésico local, hemostáticos de celulosa oxidada.
- Considerar coagulopatía (anticoagulantes, hepatopatía) y reanimación del paciente; derivar a cirugía sangrado arterial mayor, lesión vascular o persistente pese a medidas locales.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 30

Hombre de 28 años sufre un accidente con un vidrio y resulta con una herida cortante de 10 cm en el muslo izquierdo, que sangra profusamente. **¿Cuál es la mejor forma de manejar inicialmente la hemorragia?**

A Aplicación de torniquete
B Compresión directa de la herida
C Identificar y ligar el vaso sangrante
D Compresión de la arteria femoral
E Cubrir la herida con apósitos

Respuesta B. La primera medida para controlar la hemorragia externa es la compresión directa y sostenida sobre la herida, que controla la gran mayoría de los sangrados. El torniquete se reserva para hemorragias de extremidades que no ceden con compresión directa o amenazan la vida. Pinzar o ligar vasos a ciegas en urgencia puede dañar nervios y estructuras vecinas.

▶ VER CLASE 4.01.5.018 Intubación traqueal

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: incapacidad de proteger la vía aérea (Glasgow ≤8), obstrucción o riesgo inminente (quemadura de vía aérea, trauma facial), falla respiratoria (hipoxemia o hipercapnia refractarias), paro cardiorrespiratorio, shock grave.
- Preparación (SOAP-ME): aspiración, oxígeno (preoxigenación al 100% por 3-5 min), vía aérea (laringoscopio, tubos 7-8 en mujer y 8-8,5 en hombre, guía, bougie), posición en olfateo, fármacos, monitoreo y equipo de rescate.
- Secuencia de intubación rápida: inducción (ketamina 1-2 mg/kg, etomidato 0,3 mg/kg o propofol) + relajante (succinilcolina 1-1,5 mg/kg o rocuronio 1,2 mg/kg); en trauma, estabilización cervical manual en línea.
- Confirmación: visualizar paso por cuerdas, capnografía (gold standard), auscultación bilateral y epigástrica, empañamiento; fijar a 21 cm (mujer) o 23 cm (hombre) en comisura labial; Rx: punta 3-5 cm sobre carina.
- Complicaciones: intubación esofágica, monobronquial derecha, hipoxemia, aspiración, trauma dental o laríngeo, hipotensión post inducción. Si falla tras intentos: dispositivo supraglótico y, si no se oxigena, cricotiroidotomía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 90

Durante la reanimación de un paciente se realiza una intubación orotraqueal. **¿Cuál es el parámetro ideal para confirmar que el tubo quedó en la tráquea?**

A Pulsometría
B Auscultación pulmonar
C Capnografía
D Oximetría
E Expansión torácica

Respuesta C. La capnografía con onda continua es el método más confiable para confirmar y monitorizar la posición del tubo en la tráquea, porque detecta CO2 espirado en cada ventilación. La auscultación y la expansión torácica pueden engañar (por ejemplo, en una intubación esofágica), y la oximetría cae tardíamente.

▶ VER CLASE 4.01.5.019 Intubación nasogástrica

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.12 · Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: descompresión gástrica (obstrucción intestinal, íleo, pancreatitis grave, trauma), lavado gástrico seleccionado, administración de alimentación o fármacos, diagnóstico de HDA.
- Contraindicación: fractura de base de cráneo o trauma facial grave (riesgo de paso intracraneano: usar vía orogástrica), estenosis/cirugía esofágica reciente, ingesta de cáusticos; precaución en várices esofágicas y coagulopatía.
- Técnica: medir nariz-lóbulo de la oreja-apéndice xifoides (~50-60 cm adulto), lubricar, paciente sentado con cuello flectado, introducir por narina y pedir que trague (sorbos de agua).
- Confirmación: aspiración de contenido gástrico (pH <5), Rx de tórax/abdomen (de elección antes de alimentar; punta bajo el diafragma); auscultación de aire insuflado no es confiable. Tos, disnea o cianosis sugieren vía aérea: retirar.
- Cuidados: fijación, cuantificar y reponer pérdidas (alcalosis metabólica hipoclorémica e hipokalémica), permeabilidad, lesiones de ala nasal; complicaciones: sinusitis, epistaxis, aspiración, perforación.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 35 años ingresa tras un accidente de tránsito con traumatismo encéfalo-craneano. Presenta equimosis periorbitaria bilateral (ojos de mapache), equimosis retroauricular y salida de líquido claro por la nariz. Se requiere descomprimir el estómago. **¿Cuál es la forma más adecuada de hacerlo?**

A Sonda nasogástrica

B Sonda nasoyeyunal

C Sonda orogástrica

D Gastrostomía percutánea de urgencia

E No descomprimir el estómago

Respuesta C. Los signos de fractura de base de cráneo (ojos de mapache, signo de Battle, rinorrea u otorraquia de líquido cefalorraquídeo) contraindican la instalación de sondas por vía nasal, por riesgo de que la sonda ingrese a la cavidad craneana a través de la lámina cribosa. En estos casos la descompresión gástrica se realiza por vía orogástrica.

▶ VER CLASE 4.01.5.020 Inyecciones subcutáneas, intramusculares e intravenosas

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.3 · Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026

QUÉ HAY QUE SABER

- Subcutánea: tejido celular subcutáneo de abdomen periumbilical, brazo o muslo, ángulo de 45-90° con aguja corta (insulina, heparina de bajo peso molecular, vacunas como tresvírica); rotar sitios para evitar lipodistrofia.
- Intramuscular: deltoides (hasta 2-3 ml; vacunas en adultos), vasto lateral del muslo (sitio de elección en lactantes), ventroglúteo o cuadrante superoexterno del glúteo (evitar nervio ciático); ángulo de 90°.
- Intravenosa: bolo o infusión por vía venosa periférica permeable; verificar retorno venoso, velocidad adecuada, compatibilidad y dilución.
- Normas generales: los «5 correctos» (paciente, fármaco, dosis, vía, hora), higiene de manos, asepsia de la piel, registrar, preguntar por alergias, descartar cortopunzantes sin reencapuchar.
- Complicaciones: dolor, hematoma, absceso, lesión nerviosa (IM), extravasación y flebitis (IV), reacciones anafilácticas (tener adrenalina disponible: 0,01 mg/kg IM, máx 0,5 mg).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 2 meses acude al vacunatorio para recibir las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones, incluida la hexavalente por vía intramuscular. **¿Cuál es el sitio de elección para la inyección intramuscular a esta edad?**

A Región glútea, cuadrante superior externo

B Músculo deltoides

C Región ventroglútea

D Cara anterolateral del muslo (vasto lateral)

E Cara anterior del antebrazo

Respuesta D. En lactantes menores de 12 a 18 meses, el sitio de elección para inyecciones intramusculares es el vasto lateral, en la cara anterolateral del muslo, por su mayor masa muscular y ausencia de grandes vasos y nervios. El deltoides es pequeño a esta edad, y el glúteo se evita por riesgo de lesionar el nervio ciático.

▶ VER CLASE 4.01.5.021 Manejo de drenajes

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.21 · Procedimientos de Cirugía Menor: Punción Venosa, Manejo de Drenajes, Onicocriptosis & Onicectomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Drenajes: pasivos (Penrose, por capilaridad y gravedad) o activos/aspirativos (Jackson-Pratt, Hemovac/Redon); abiertos o cerrados (menor infección). Tubo pleural es un drenaje con sello de agua.
- Objetivos: evacuar colecciones (sangre, bilis, pus, seroma), prevenir acumulación en espacio muerto y detectar precozmente complicaciones (sangrado, filtración anastomótica, fístula biliar o pancreática).
- Vigilancia diaria: cantidad (registrar débito cada turno), aspecto (hemático, serohemático, seroso, bilioso, purulento, intestinal/fecaloide), funcionamiento y permeabilidad, piel del sitio de salida.
- Signos de alarma: débito hemático abundante (>100-200 ml/h) o creciente, cambio a bilioso, fecaloide o purulento, fiebre → avisar al cirujano.
- Cuidados: fijar a piel, mantener el reservorio bajo el nivel de inserción y el vacío en los aspirativos, curaciones con técnica aséptica; retiro cuando el débito es mínimo (habitualmente <25-50 ml/día) y seroso, sin pinzar bruscamente.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 6

Hombre de 76 años, con secuela de un accidente vascular encefálico, se alimenta mediante una gastrostomía realizada por vía endoscópica hace 2 meses. Accidentalmente se retiró la sonda. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar radiografía simple de abdomen
B Solicitar ecografía abdominal
C Solicitar TAC de abdomen
D Instalar una nueva sonda por el ostoma
E Realizar una nueva gastrostomía

Respuesta D. Pasadas 4 a 6 semanas, el trayecto gastrocutáneo de una gastrostomía ya está maduro, por lo que ante un retiro accidental debe reinstalarse una sonda por el mismo ostoma lo antes posible, ya que el orificio puede cerrarse en pocas horas. Si el trayecto es reciente, el riesgo de falsa vía exige reinstalación bajo visión endoscópica o radiológica.

▶ VER CLASE 4.01.5.022 Manejo de vía aérea y columna cervical en trauma

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Asumir lesión de columna cervical en todo politraumatizado, especialmente con trauma por sobre las clavículas, TEC, alteración de conciencia o mecanismo de alta energía.
- Restricción de movimiento cervical: estabilización manual en línea por un ayudante durante cualquier maniobra; luego collar cervical rígido, inmovilizadores laterales y tabla espinal; movilizar en bloque.
- Apertura de vía aérea sin hiperextender: tracción mandibular (jaw thrust) o elevación del mentón; aspirar secreciones y sangre, retirar cuerpos extraños; cánula orofaríngea si inconsciente sin reflejo nauseoso (nasofaríngea contraindicada si sospecha de fractura de base de cráneo).
- Vía aérea definitiva si Glasgow ≤8, vía aérea en riesgo (quemadura, hematoma cervical expansivo, trauma facial grave), apnea o hipoxemia refractaria: intubación orotraqueal con secuencia rápida y estabilización en línea (retirar parte anterior del collar). Si fracasa: cricotiroidotomía.
- Oxígeno a alto flujo con mascarilla de no reinhalación (10-15 L/min). Retirar collar solo cuando se descarta lesión clínica (NEXUS/canadiense) o radiológicamente.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 35 años, traída tras un volcamiento, está inconsciente y con ronquido. Se sospecha lesión de columna cervical. No tiene trauma facial ni sangre en la boca. **¿Cuál es la maniobra inicial más adecuada para permeabilizar la vía aérea?**

A Hiperextensión del cuello con elevación del mentón
B Intubación nasotraqueal a ciegas
C Retirar el collar cervical para evaluar el cuello
D Tracción mandibular manteniendo inmovilización manual alineada de la columna cervical
E Colocar a la paciente en posición lateral de seguridad

Respuesta D. En trauma con sospecha de lesión cervical, la vía aérea se abre con tracción mandibular, o elevación del mentón sin extender el cuello, manteniendo la inmovilización manual alineada. La hiperextensión puede agravar una lesión medular. Si no se logra una vía aérea adecuada, se avanza a cánula y vía aérea definitiva.

▶ VER CLASE 4.01.5.023 Manejo ventilatorio básico

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.1 · Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Oxigenoterapia: meta SatO2 94-98% (88-92% en EPOC retenedor de CO2). Naricera 1-6 L/min (FiO2 ~24-44%), mascarilla simple 5-10 L/min, Venturi (FiO2 precisa 24-50%), mascarilla con reservorio 10-15 L/min (FiO2 ~60-90%); cánula nasal de alto flujo.
- Ventilación con bolsa-mascarilla (Ambú): sello en «C-E» con una o dos manos, cánula orofaríngea, 10 ventilaciones/min en adulto (1 cada 6 s), volumen que eleve visiblemente el tórax, evitar hiperventilar (distensión gástrica, aspiración).
- Ventilación no invasiva (CPAP/BiPAP): útil en EPOC exacerbado con acidosis respiratoria y edema pulmonar agudo; contraindicada si compromiso de conciencia, vómitos, inestabilidad o incapacidad de proteger la vía aérea.
- Ventilación mecánica invasiva básica: volumen corriente 6-8 ml/kg de peso ideal (protector), PEEP 5 cmH2O inicial, FiO2 para SatO2 objetivo, FR 12-20; controlar presión plateau <30 cmH2O y gases arteriales.
- Monitorizar con oximetría, capnografía, gases arteriales y clínica (trabajo respiratorio, conciencia).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 55 años es encontrado en apnea tras una intoxicación por opioides. Tiene pulso carotídeo palpable. Mientras se prepara la naloxona, usted inicia ventilación con bolsa-mascarilla y oxígeno. **¿Cuál es la técnica de ventilación más adecuada?**

A Solo oxígeno por mascarilla de alto flujo, sin ventilar

B 30 ventilaciones por minuto con el máximo volumen posible

C 2 ventilaciones cada 30 compresiones torácicas

D 1 ventilación por minuto para evitar hiperventilación

E 1 ventilación cada 6 segundos (10 por minuto), con volumen suficiente para elevar visiblemente el tórax

Respuesta E. En un adulto en paro respiratorio con pulso, se ventila 1 vez cada 6 segundos, aproximadamente 10 por minuto, con volumen suficiente para elevar el tórax y durante 1 segundo cada una, sellando bien la mascarilla y abriendo la vía aérea con maniobra frente-mentón o tracción mandibular. La hiperventilación aumenta la presión intratorácica y la distensión gástrica.

▶ VER CLASE 4.01.5.024 Onicectomía

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.21 · Procedimientos de Cirugía Menor: Punción Venosa, Manejo de Drenajes, Onicocriptosis & Onicectomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Onicectomía: extirpación parcial (borde lateral) o total de la uña; indicada en onicocriptosis estadio II-III o recurrente, onicogrifosis y trauma ungueal severo.
- Anestesia: bloqueo troncular digital con lidocaína 1-2% sin epinefrina; isquemia con banda elástica en la base del ortejo por tiempo breve (retirar siempre al terminar).
- Técnica de onicectomía parcial: despegar la lámina ungueal, cortar longitudinalmente el borde afectado (2-3 mm) hasta la matriz, extraer la espícula y destruir la matriz lateral (fenol 88% por 1-3 min o resección quirúrgica) para evitar recidiva; resecar tejido de granulación.
- Contraindicaciones relativas: insuficiencia arterial (evaluar pulsos/ITB), diabetes descompensada, coagulopatía; infección activa importante se trata primero (drenaje ± antibiótico).
- Postoperatorio: vendaje compresivo, elevación, analgesia, curaciones a las 24-48 h y luego según evolución; educación sobre corte recto de uñas y calzado amplio.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años presenta su cuarto episodio en 1 año de onicocriptosis del borde lateral del ortejo mayor izquierdo, con dolor, secreción purulenta y tejido de granulación hipertrófico, pese a manejo conservador y cuidados adecuados. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Onicectomía parcial del borde afectado con matricectomía (quirúrgica o química con fenol)

B Antibiótico oral y repetir manejo conservador

C Onicectomía total sin tratar la matriz

D Amputación de la falange distal

E Antifúngico oral por 3 meses

Respuesta A. La onicocriptosis recurrente o con granuloma se trata con onicectomía parcial del borde afectado, bajo anestesia troncular digital, asociada a destrucción de la matriz ungueal correspondiente (matricectomía quirúrgica o química con fenol) para evitar la recurrencia. La onicectomía total sin tratar la matriz tiene alta recidiva y peor resultado estético.

▶ VER CLASE 4.01.5.025 Paracentesis

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.3 · Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: diagnóstica en ascitis de reciente aparición, en todo cirrótico con ascitis que se hospitaliza o presenta fiebre, dolor abdominal, encefalopatía o deterioro (descartar PBE); terapéutica (evacuadora) en ascitis a tensión o refractaria.
- Técnica: vejiga vacía, sitio en fosa ilíaca izquierda (tercio externo entre ombligo y espina ilíaca anterosuperior), evitando cicatrices y vasos epigástricos; idealmente guiada por ecografía; asepsia, anestesia local, técnica en Z.
- Estudio del líquido: recuento celular (PMN ≥250/mm³ = PBE → cefotaxima/ceftriaxona + albúmina), proteínas, albúmina para GASA (≥1,1 g/dl hipertensión portal; <1,1 carcinomatosis, TBC, pancreática), cultivo en frascos de hemocultivo, citología, ADA, amilasa.
- Paracentesis evacuadora >5 L: reponer albúmina 6-8 g por cada litro extraído para prevenir disfunción circulatoria post paracentesis.
- Coagulopatía de la cirrosis no contraindica (salvo CID o fibrinólisis evidentes); contraindicaciones relativas: infección de pared, distensión intestinal masiva, embarazo. Complicaciones: filtración de líquido, hematoma, perforación intestinal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 60 años con cirrosis y ascitis a tensión refractaria a diuréticos. Se realiza una paracentesis evacuadora, extrayendo 7 litros de líquido ascítico sin incidentes. **¿Qué medida es fundamental para prevenir la disfunción circulatoria postparacentesis?**

A Administrar furosemida endovenosa en dosis altas

B Administrar albúmina endovenosa, 6 a 8 g por litro extraído

C Administrar 3 litros de suero fisiológico

D Restringir completamente el sodio por 48 horas

E No se requiere ninguna medida adicional

Respuesta B. En paracentesis de más de 5 litros se debe reponer albúmina endovenosa, 6 a 8 g por cada litro extraído, para prevenir la disfunción circulatoria postparacentesis, que se asocia a hiponatremia, insuficiencia renal (síndrome hepatorrenal) y mayor mortalidad. Los cristaloides son menos eficaces como expansores en este contexto.

▶ VER CLASE 4.01.5.026 Drenaje pleural

NIVEL **DERIVAR A ESPECIALISTA**

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.10 · Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones del tubo pleural: neumotórax a tensión (tras descompresión con aguja), neumotórax traumático o grande/sintomático, hemotórax, empiema o derrame paraneumónico complicado, quilotórax, neumotórax en ventilación mecánica.
- Sitio: 4°-5° espacio intercostal entre línea axilar anterior y media («triángulo de seguridad»), sobre el borde superior de la costilla inferior para evitar el paquete vasculonervioso.
- Técnica: asepsia, anestesia local, incisión, disección roma, exploración digital del espacio pleural, introducción del tubo (28-32 Fr en hemotórax de trauma; menores en neumotórax), conexión a sello de agua y fijación; Rx de control.
- Vigilar: oscilación (permeabilidad), burbujeo (fuga aérea), débito; hemotórax >1500 ml inicial o >200 ml/h por 2-4 h indica toracotomía. Nunca pinzar un tubo que burbujea.
- Nivel del perfil: reconocer la indicación y derivar al especialista (cirujano); el médico general debe descomprimir con aguja un neumotórax a tensión.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años con herida por arma blanca en el hemitórax derecho, hemodinámicamente estable. La radiografía de tórax muestra un hemotórax moderado. Se decide instalar un tubo de drenaje pleural. **¿Cuál es el sitio y la técnica correctos de inserción?**

A Segundo espacio intercostal, línea medioclavicular, por el borde inferior de la costilla superior

B Cuarto espacio intercostal paraesternal, junto al esternón

C Octavo espacio intercostal, línea escapular, por el borde inferior de la costilla

D Quinto espacio intercostal, entre las líneas axilares anterior y media, por el borde superior de la costilla inferior

E Cualquier espacio intercostal donde se palpe mejor el derrame

Respuesta D. El tubo pleural se instala en el triángulo de seguridad: quinto espacio intercostal, entre las líneas axilares anterior y media, rasando el borde superior de la costilla inferior, porque el paquete vasculonervioso corre por el borde inferior de cada costilla. El segundo espacio medioclavicular es el sitio de punción descompresiva clásica.

▶ VER CLASE 4.01.5.027 Punción venosa

NIVEL **REALIZAR**

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.21 · Procedimientos de Cirugía Menor: Punción Venosa, Manejo de Drenajes, Onicocriptosis & Onicectomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: toma de muestras sanguíneas, instalación de vía venosa periférica para fluidos, fármacos y transfusiones.
- Sitios: venas del pliegue del codo (cubital media, cefálica, basílica) para muestras; antebrazo y dorso de la mano para catéteres. Evitar extremidad con fístula AV, vaciamiento axilar, linfedema, flebitis o infección.
- Técnica: higiene de manos y guantes, ligadura 7-10 cm proximal, asepsia con alcohol 70% o clorhexidina, punción con bisel hacia arriba a 15-30°, confirmar reflujo, avanzar catéter retirando la aguja, soltar la ligadura, fijar y registrar.
- Calibre según necesidad: 14-16 G en trauma/shock (mayor flujo: catéter corto y grueso), 18-20 G uso general, 22-24 G en niños/venas finas.
- Complicaciones: hematoma, flebitis, extravasación, infección, punción arterial. Cambiar catéter periférico según protocolo o ante signos de flebitis; si no se logra acceso en emergencia, vía intraósea.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un interno realiza una punción venosa en el pliegue del codo para tomar exámenes de sangre a un paciente adulto. **¿Cuál de las siguientes prácticas es correcta?**

A Mantener la ligadura más de 3 minutos para mejorar el llenado venoso

B Reencapuchar la aguja con ambas manos después de la extracción

C Puncionar sobre una zona con hematoma reciente

D Pedir al paciente que abra y cierre el puño repetidamente durante toda la extracción

E Introducir la aguja con el bisel hacia arriba, en ángulo de 15 a 30 grados, y soltar la ligadura antes de retirarla

Respuesta E. La punción venosa se realiza con el bisel hacia arriba, en un ángulo de 15 a 30 grados, y se suelta la ligadura antes de retirar la aguja para evitar hematomas. La ligadura no debe mantenerse más de 1 minuto, y el bombeo del puño produce falsa hiperkalemia. Nunca se reencapucha la aguja.

▶ VER CLASE 4.01.5.028 Resucitación cardiorrespiratoria

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cardiología** 1.2 · Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

QUÉ HAY QUE SABER

- Cadena de supervivencia: reconocer el paro (no responde, no respira o solo jadea, sin pulso en ≤10 s), activar el sistema de emergencia, RCP precoz, desfibrilación precoz, soporte avanzado y cuidados post paro.
- Compresiones de alta calidad: centro del tórax, 100-120/min, profundidad 5-6 cm en adulto (1/3 del diámetro AP en niños), permitir reexpansión completa, interrupciones <10 s, cambiar reanimador cada 2 min.
- Relación compresión:ventilación 30:2 en adulto (15:2 con 2 reanimadores en niños); con vía aérea avanzada, compresiones continuas y 1 ventilación cada 6 s. Lego no entrenado: solo compresiones.
- Desfibrilador: colocar en cuanto esté disponible; FV/TV sin pulso → descarga (bifásico 120-200 J; niños 2-4 J/kg) seguida inmediatamente de 2 min de RCP; adrenalina 1 mg IV/IO cada 3-5 min; amiodarona 300 mg tras la 3ª descarga.
- Asistolia/AESP: RCP + adrenalina precoz y tratar causas reversibles (5H y 5T). Terminar esfuerzos según criterio clínico tras RCP prolongada sin respuesta; registro de tiempos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 60 años colapsa en la calle. No responde y no respira normalmente. Usted pide ayuda, solicita un desfibrilador externo automático e inicia la reanimación cardiopulmonar. **¿Cuáles son las características correctas de las compresiones torácicas en el adulto?**

A Frecuencia de 60 a 80 por minuto, profundidad de 2 a 3 cm

B Frecuencia de 150 por minuto, profundidad de 8 cm

C Frecuencia de 100 a 120 por minuto, profundidad de 5 a 6 cm, permitiendo la reexpansión completa del tórax, con relación 30:2

D Relación 15:2 con pausas largas para evaluar pulso cada minuto

E Frecuencia de 100 por minuto sobre el tercio superior del esternón

Respuesta C. Las compresiones de alta calidad en el adulto se realizan en la mitad inferior del esternón, a 100 a 120 por minuto, con profundidad de 5 a 6 cm, permitiendo la reexpansión completa del tórax y minimizando interrupciones; sin vía aérea avanzada, la relación es de 30 compresiones por 2 ventilaciones. La relación 15:2 corresponde a 2 reanimadores en niños.

▶ VER CLASE 4.01.5.029 Punción pleural

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 3.1 · Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light

QUÉ HAY QUE SABER

- Toracocentesis diagnóstica: todo derrame pleural nuevo de causa no evidente (>1 cm en decúbito lateral o ecografía); evacuadora: derrame sintomático (disnea).
- Técnica: paciente sentado inclinado hacia adelante, punción en línea axilar posterior o escapular 1-2 espacios bajo el nivel de matidez (no bajo el 8°-9° espacio), sobre el borde superior de la costilla; idealmente guiada por ecografía; asepsia y anestesia local.
- Análisis: aspecto, proteínas y LDH (criterios de Light con valores séricos), glucosa, pH, recuento celular y diferencial, Gram y cultivo, ADA (TBC), citología; triglicéridos si aspecto lechoso.
- No extraer más de 1-1,5 L por sesión (riesgo de edema pulmonar por reexpansión); suspender si tos, dolor torácico o disnea.
- Complicaciones: neumotórax (Rx de control si síntomas o aspiración de aire), hemotórax, lesión hepática/esplénica, reacción vasovagal, infección. Contraindicaciones relativas: coagulopatía grave, infección de la pared.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 65 años con un derrame pleural derecho moderado requiere una toracocentesis diagnóstica. Se ubica sentada, inclinada hacia adelante, y se identifica el nivel del derrame por percusión y ecografía. **¿Dónde debe introducirse la aguja respecto de la costilla?**

A Por el borde inferior de la costilla superior

B En el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular

C Por el centro del cuerpo costal

D Por el borde superior de la costilla inferior

E Por cualquier borde, ya que no hay estructuras relevantes

Respuesta D. El paquete vasculonervioso intercostal (vena, arteria y nervio) transcurre por el surco del borde inferior de cada costilla. Por eso la punción pleural se realiza rozando el borde superior de la costilla inferior del espacio elegido, habitualmente en la línea axilar posterior, uno o dos espacios bajo el nivel del derrame, idealmente guiada por ecografía.

▶ VER CLASE 4.01.5.030 Traqueostomía y cricoidostomía

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.1 · Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Traqueostomía: vía aérea quirúrgica a través de los anillos traqueales (2°-4°), procedimiento electivo o semielectivo; indicada en ventilación mecánica prolongada (>7-14 días), obstrucción de vía aérea superior crónica (tumores, parálisis de cuerdas), manejo de secreciones y apnea obstructiva grave.
- Cricotiroidotomía: vía aérea quirúrgica de urgencia a través de la membrana cricotiroidea (más rápida, superficial y con menos sangrado); temporal, convertir a traqueostomía en 24-72 h.
- Traqueostomía percutánea (en UCI) o abierta (pabellón); complicaciones: sangrado, enfisema subcutáneo, neumotórax, falsa vía, decanulación accidental, infección, estenosis traqueal, fístula traqueoesofágica o traqueoinnominada (sangrado masivo).
- Cuidados de la traqueostomía: aspiración de secreciones con técnica estéril, humidificación, curación del estoma, control de presión del cuff (20-30 cmH2O), cánula de repuesto y obturador junto al paciente.
- Nivel del perfil: la traqueostomía la realiza el especialista; el médico general reconoce la indicación, maneja la cánula obstruida o desplazada y deriva.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años con neumonía grave lleva 14 días en ventilación mecánica invasiva por tubo orotraqueal, con varios intentos fallidos de desconexión. Se estima que requerirá soporte ventilatorio prolongado. **¿Cuál es el procedimiento más adecuado para su vía aérea?**

A Cricotiroidotomía quirúrgica

B Mantener indefinidamente el tubo orotraqueal

C Traqueostomía electiva

D Punción cricotiroidea con aguja

E Cambio a mascarilla laríngea

Respuesta C. En pacientes que requieren ventilación mecánica prolongada, la traqueostomía electiva, quirúrgica o percutánea, facilita el destete, mejora el confort, la higiene oral y la aspiración de secreciones, y disminuye el daño laríngeo por intubación prolongada. La cricotiroidotomía es un procedimiento de urgencia para el escenario de no intubable y no oxigenable, y debe convertirse luego en traqueostomía.

▶ VER CLASE 4.01.5.031 Traslado del traumatizado

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Antes del traslado: estabilizar según ABCDE (vía aérea segura, ventilación, control de hemorragia, accesos venosos, inmovilización espinal y de fracturas), sin retrasar el traslado de un paciente que requiere cirugía.
- Inmovilización: collar cervical rígido, tabla espinal o colchón de vacío, inmovilizadores laterales y correas; movilizar en bloque (maniobra de rodado con 3-4 personas); férulas en fracturas de extremidades y faja pelviana si fractura de pelvis inestable.
- Elegir el destino según recursos necesarios (centro de trauma), no por cercanía; comunicación médico a médico previa, con resumen clínico y tratamiento realizado.
- Durante el traslado: monitoreo continuo (signos vitales, oximetría, Glasgow), oxígeno, fluidos tibios, prevención de hipotermia, personal capacitado y equipamiento para manejo de vía aérea.
- Documentación: registro de hora del trauma, mecanismo, hallazgos, intervenciones (incluida hora de torniquete), fármacos y evolución; embarazada en decúbito lateral izquierdo (inclinar la tabla).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 25 años, víctima de un volcamiento, se encuentra consciente, con dolor cervical y parestesias en ambas manos. El equipo prehospitalario debe extraerla y trasladarla al servicio de urgencia. **¿Cuál es la forma más adecuada de traslado?**

A Sentada en el asiento del vehículo de emergencia

B Inmovilización con collar cervical rígido y tabla espinal, movilizándola en bloque

C Permitir que camine hasta la ambulancia si puede hacerlo

D Trasladarla en decúbito lateral sin collar

E Retirar el casco y el collar para facilitar la evaluación durante el traslado

Respuesta B. Ante sospecha de lesión de columna (mecanismo de alta energía, dolor cervical, síntomas neurológicos), la paciente debe trasladarse con restricción de movimiento espinal: collar cervical rígido, tabla espinal o camilla de cuchara, y movilización en bloque con varios rescatadores, manteniendo la alineación del eje cabeza-cuello-tronco hasta descartar la lesión en el hospital.

▶ VER CLASE 4.01.5.032 **Vendajes e inmovilizaciones con férulas** NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.1 · Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización

QUÉ HAY QUE SABER

- Objetivos: inmovilizar fracturas, luxaciones reducidas y esguinces para aliviar dolor, evitar lesión neurovascular adicional y facilitar el traslado; incluir la articulación proximal y distal.
- Tipos: férulas de yeso o fibra (valvas), férulas prefabricadas, cabestrillo, vendaje elástico compresivo, vendaje funcional; yeso circular solo cuando ya no se espera edema (riesgo de síndrome compartimental).
- Evaluar y registrar estado neurovascular distal (pulso, llene capilar, sensibilidad, motilidad) antes y después de inmovilizar; inmovilizar en posición funcional.
- Signos de alarma: dolor desproporcionado (sobre todo a la extensión pasiva de los dedos), parestesias, palidez, frialdad → retirar o abrir vendaje/yeso de inmediato y evaluar síndrome compartimental.
- Nivel del perfil: inmovilización provisoria y derivación a traumatología para tratamiento definitivo; indicar elevación, frío local y analgesia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años sufre una fractura de radio distal no desplazada hace 3 horas. Presenta edema moderado de la muñeca y antebrazo. Se decide tratamiento ortopédico. **¿Cuál es la inmovilización inicial más adecuada?**

A Yeso circular cerrado ajustado

B Sin inmovilización, con analgesia

C Vendaje elástico compresivo exclusivo

D Férula (valva) de yeso antebraquiopalmar, no circular, con extremidad elevada

E Yeso braquiopalmar circular cerrado

Respuesta D. En una fractura aguda con edema, la inmovilización inicial debe ser una férula o valva no circular, que inmoviliza las articulaciones vecinas y permite el aumento de volumen sin comprimir, previniendo un síndrome compartimental. Se indica elevar la extremidad, mover los dedos y vigilar dolor y perfusión; el yeso circular se coloca cuando cede el edema.

13

TRAUMATOLOGÍA

45 CÓDIGOS

120 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	9
Situaciones clínicas de urgencia	15
Conocimientos generales	7
Exámenes e imagenología	9
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	5

Situaciones clínicas

9 códigos

▶ VER CLASE **4.02.1.001** **Artrosis primarias y secundarias** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.12 · Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica

QUÉ HAY QUE SABER

- Artrosis: destrucción progresiva del cartílago; primaria (degenerativa, genética) o secundaria (fracturas intraarticulares, luxaciones crónicas, artritis reumatoide o séptica previa).
- Clínica: dolor mecánico (empeora con el uso, cede con reposo), rigidez matinal <30 min, crepitación, derrame no inflamatorio; Heberden (IFD), Bouchard (IFP), rizartrosis; coxartrosis con dolor inguinal y pérdida de rotación interna.
- Confirmación con radiografía en carga: pinzamiento asimétrico, esclerosis subcondral, osteofitos y geodas, sin osteopenia ni erosiones. Líquido sinovial no inflamatorio (<2.000 leucocitos).
- Tratamiento inicial: baja de peso, ejercicio y fortalecimiento de cuádriceps; paracetamol 1 g c/8 h (hasta 3–4 g/día); AINE breves si no basta (evitar en IRC, úlcera, insuficiencia cardíaca: usar tramadol).
- Infiltración con corticoide intraarticular en brotes; prótesis o artrodesis como última línea (GES endoprótesis total de cadera en mayores de 65 con artrosis severa).
- Seguimiento completo en APS: control de dolor y función, peso y adherencia al ejercicio; derivar a traumatología si hay dolor refractario e incapacidad.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 139

Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, consulta por dolor de la rodilla izquierda, de 4 semanas de evolución, que le dificulta la marcha. Al examen físico, su rodilla no tiene alteraciones. **¿Qué otra articulación se debe examinar?**

A La cadera
B La sínfisis del pubis
C La sacroilíaca
D El tobillo
E La articulación astragalotarsiana

Respuesta A. Recordar que la patología de cadera puede producir gonalgia (dolor de rodilla).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 5

Un paciente de 77 años presenta dolor inguinal derecho de 2 años de evolución, que aumenta con la marcha, limitándola. Al examen físico se aprecia pérdida de la rotación interna y la flexión de la cadera derecha. **El diagnóstico más probable es:**

A Necrosis avascular de la cabeza femoral
B Coxartrosis
C Hernia foraminal S1
D Pinzamiento femoroacetabular
E Estenosis raquimedular

Respuesta B. Dolor inguinal que lleva dos años, aumenta con la marcha y se acompaña de pérdida de la rotación interna y la flexión de la cadera, en un adulto mayor: coxartrosis, la artrosis de cadera.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 58 años con insuficiencia renal crónica estadio 3 y úlcera duodenal activa consulta por artrosis de cadera con dolor que no cede con paracetamol. **¿Cuál es el siguiente paso correcto en el manejo?**

A Agregar ibuprofeno más omeprazol como protección gástrica
B Agregar celecoxib, ya que los COX-2 no producen úlcera
C Tramadol oral, saltando el escalón de los AINE por contraindicación
D Corticoides orales en dosis bajas como antiinflamatorio alternativo
E Derivar directamente a cirugía por la complejidad del caso

Respuesta C. Con insuficiencia renal crónica o úlcera péptica activa los AINE están contraindicados, aunque se agregue omeprazol y aunque sean COX-2, que siguen siendo riesgosos para el riñón. El tratamiento salta del paracetamol al tramadol. Los corticoides orales no forman parte de la escalera, y la cirugía es la última línea.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 52

Un paciente de 63 años consulta por dolor progresivo, de una semana de evolución, en la cara lateral de la cadera, que aumenta con la caminata y limita sus movimientos. Además, en el último tiempo, le impide dormir para ese lado. Al examen físico tiene dolor a la palpación de la cara externa de la cadera y a la rotación externa forzada. El diagnóstico más probable es:

A Coxartrosis

B Fractura incompleta de cadera por estrés

C Hernia del núcleo pulposo, con radiculopatía L2

D Bursitis trocantérica

E Síndrome de la fascia lata rígida

Respuesta D. Diagnóstico: Bursitis trocantérica (opción D). Parece una bursitis trocantérica clásica. La artrosis (osteoartritis) es la patología articular más frecuente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 14

Pregunta 14 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un paciente de 78 años consulta por dolor en ambas ingles, irradiado a los muslos, que inició hace 5 años y que es más intenso al caminar, lo que ha limitado su movilidad en el último tiempo. Se solicita una radiografía AP de pelvis, que se muestra a continuación: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Displasia de caderas

B Mestástasis óseas

C Necrosis avascular de la cabeza femoral bilateral

D Sacroileítis

E Coxoartrosis bilateral

Respuesta E. Diagnóstico: Coxoartrosis bilateral (opción E). Es una artrosis de cadera, tanto por la clínica, como por la radiografía. La artrosis (osteoartritis) es la patología articular más frecuente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 120

Una paciente de 30 años, con antecedente de displasia de cadera derecha, tratada con cirugía abierta en su infancia, consulta por dolor muy intenso en la cadera izquier- da, que la hace cojear permanentemente. Al examen físico presenta acortamiento de 25

A Tratamiento sintomático de la artrosis

B Indicar tratamiento kenesioterapéutico

C Realizar osteotomía acetabular

D Instalar prótesis total de cadera

E Compensar el acortamiento con calzado con realce

Respuesta D. En mi opinión tiene indicación de reemplazo articular. Pero la decisión exacta co- rresponde al especialista, según cada caso.

▶ VER CLASE 4.02.1.002 Displasia congénita de cadera

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Pediatría 18.22 · Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik
Traumatología 12.14 · Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Factores de riesgo: sexo femenino, presentación podálica, antecedente familiar de primer grado. Problema de salud GES.
- Menor de 3 meses: Ortolani (reduce con resalto) y Barlow (luxa la cadera inestable); mayor de 3 meses: abducción limitada <60° y signo de Galeazzi.
- Confirmación: ecografía bajo los 3 meses si hay hallazgos; radiografía de pelvis a los 3 meses a todos los lactantes. Displasia: índice acetabular >30°, núcleo o metáfisis fuera del cuadrante ínfero-interno (Hilgenreiner-Perkins), ruptura del arco de Shenton.
- Tratamiento inicial: derivar a traumatología infantil; menor de 6 meses arnés de Pavlik (flexión 90–100° con abducción moderada, nunca forzada por riesgo de necrosis).
- Si falla o el diagnóstico es tardío: reducción bajo anestesia con yeso pelvipédico o reducción cruenta. Sin tratamiento evoluciona a artrosis precoz y cojera.
- Seguimiento: derivar a ortopedia infantil; el doble pañal no es tratamiento.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 137

Niño diagnosticado de displasia de cadera a los 6 meses de vida, mediante radiografía que muestra luxación del extremo proximal del fémur izquierdo. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A Doble pañal

B Correas de Pavlik

C Yeso con fijador

D Osteotomía periacetabular tipo Ganz

E Reducción abierta y fijación con osteosíntesis

Respuesta B. A los 6 meses todavía está dentro de la ventana en que el arnés de Pavlik funciona como tratamiento de elección. La cirugía y la osteotomía quedan para el niño mayor o para cuando el arnés fracasa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 7

Niño de 3 meses de edad, radiografía de pelvis que muestra displasia de cadera izquierda, con índice acetabular de 36 grados. **¿Cuál es la indicación más adecuada?**

A Ejercicios de rotación y compresión
B Bota larga bilateral de yeso, con yugo
C Yeso pelvipédico
D Uso de doble pañal
E Arnés de Pavlik

Respuesta E. Un índice acetabular de 36 grados a los 3 meses está sobre el corte normal de 30, y confirma la displasia. En un lactante de esta edad, el tratamiento es arnés de Pavlik.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 130

Niño de 9 años con cojera indolora progresiva de 3 semanas. Rx de cadera: aplanamiento y fragmentación de la cabeza femoral derecha. ¿Cuál es el diagnóstico y conducta? **¿Cuál es el diagnóstico y conducta?**

A Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes: derivar a ortopedia infantil
B Sinovitis transitoria: reposo y AINEs
C Artritis séptica: hospitalizar y cirugía
D Displasia del desarrollo de cadera: arnés de Pavlik
E Osteosarcoma: biopsia urgente

Respuesta A. Necrosis avascular de la cabeza femoral en un niño de 4 a 10 años, con radiografía de fragmentación y aplanamiento: enfermedad de Perthes. Se deriva a ortopedia para decidir tratamiento conservador o quirúrgico.

▶ VER CLASE 4.02.1.003 Escoliosis y deformidades vertebrales

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.14 · Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Escoliosis: desviación lateral de la columna con rotación vertebral; sospechar ante asimetría de hombros, escápulas o talle, sobre todo en niñas adolescentes.
- Test de Adams: giba costal al inclinarse hacia adelante indica escoliosis estructural (la actitud postural no tiene giba).
- Ante sospecha, radiografía de columna completa de pie para medir el ángulo de Cobb.
- Conducta según Cobb: <30° observación y ejercicios; 30–50° corsé; >50° cirugía (artrodesis).
- Banderas rojas: dolor, curva torácica izquierda, déficit neurológico o progresión rápida obligan a buscar causa secundaria (tumor, siringomielia).
- Seguimiento: derivar a traumatología infantil para control radiológico durante el crecimiento.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 122

Una paciente de 63 años presenta dolor dorsal intenso, que inició hace 5 días, en relación a un esfuerzo en flexión y que ha aumentado, limitando significativamente sus actividades de la vida diaria. Tiene antecedente de una fractura de muñeca hace un año, que requirió tratamiento quirúrgico. Al examen físico se aprecia adolorida, con signos vitales normales, dolor a la movilización activa y pasiva de su columna dorsal, que limita los movimientos de flexo-extensión. A la inspección la curvatura dorsal se observa redonda, sin cifosis. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hernia del núcleo pulposo
B Tuberculosis vertebral
C Espondilolistesis dorsal
D Espondilosis dorsal
E Fractura vertebral

Respuesta E. Dolor dorsal agudo tras un esfuerzo mínimo en una mujer con fractura de muñeca previa: fractura vertebral por aplastamiento osteoporótica. Dos fracturas por fragilidad: osteoporosis clínica, que se trata aunque no haya DEXA.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una niña de 13 años es llevada por su madre porque se le nota un hombro más alto. Al inclinarse hacia adelante se ve una giba costal derecha. La radiografía de columna muestra una escoliosis torácica con un ángulo de Cobb de 38 grados. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solo ejercicios y observación
B Corsé
C Artrodesis de columna
D Tranquilizar: es una actitud escoliótica
E Reposo en cama

Respuesta B. La giba costal con el test de Adams confirma una escoliosis verdadera, no una actitud postural. Con una desviación de 38 grados, entre 30 y 50, corresponde corsé. Los ejercicios y la observación son para menos de 30 grados, y la cirugía para más de 50.

▶ VER CLASE 4.02.1.004 Infecciones osteoarticulares

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Traumatología 12.11 · Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis
Traumatología 12.12 · Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica

QUÉ HAY QUE SABER

- Artritis séptica: monoartritis aguda con fiebre y dolor intenso a la movilización activa y pasiva de una articulación grande (rodilla, cadera, hombro); S. aureus es el agente principal; gonococo en joven sexualmente activo.
- Confirmación: artrocentesis antes del antibiótico: líquido turbio >50.000 leucocitos, >90 % PMN, glucosa <50 % de la glicemia; Gram (poco sensible) y cultivo; hemocultivos ×2. Los cristales no descartan infección.
- Osteomielitis y espondilodiscitis: dolor óseo localizado, fiebre, VHS/PCR altas; RM con gadolinio es el examen de elección (la radiografía se altera tarde); hemocultivos y biopsia si son negativos.
- Tratamiento inicial: hospitalizar, antibiótico EV empírico (cefazolina 2 g c/8 h o cloxacilina; vancomicina si riesgo de SAMR; ceftriaxona si gonococo o gramnegativos) y drenaje articular urgente.
- La cadera es una emergencia quirúrgica (riesgo de necrosis avascular). Diferenciar de bursitis (superficial, movilidad pasiva conservada). Infección protésica: recambio y rifampicina.
- Seguimiento: derivar a traumatología para drenaje y control; antibiótico prolongado (3–6 semanas).

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 126

Hombre de 60 años con dolor, calor y aumento de volumen en la rodilla derecha de inicio súbito. Artrocentesis: líquido turbio, 50.000 GB con 90% PMN. Gram: cocos gram positivos en racimos. ¿Cuál es el diagnóstico?

A Artritis séptica por Staphylococcus aureus
B Gota aguda
C Artritis reumatoide
D Pseudogota (artritis por pirofosfato)
E Artritis reactiva

Respuesta A. Artritis séptica confirmada por recuento sinovial de 50.000 leucocitos/mm³ con 90% de neutrófilos y tinción de Gram demostrando cocos grampositivos en racimo, compatible con Staphylococcus aureus. Requiere drenaje articular urgente y antibióticos antiestafilocócicos EV.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 167

Paciente de 67 años, con antecedente de pielonefritis tratada hace 2 meses, presenta dolor lumbar desde hace 1 mes que se ha ido intensificando, asociado a sensación febril durante los últimos días. Al examen físico tiene temperatura de 38 °C y dolor a la palpación de la zona lumbar media. La radiografía lumbar muestra aplastamiento de L2 y L3, con imagen radiolúcida alrededor del disco intervertebral. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Osteosarcoma
B Pielonefritis aguda
C Osteoma osteoide
D Espondilodiscitis
E Espondilolistesis

Respuesta D. Lumbago progresivo con fiebre tras una bacteriemia de origen urinario, con erosión de dos platillos vertebrales contiguos y del disco entre ellos, es espondilodiscitis (siembra hematógena). La infección cruza el disco; los tumores típicamente lo respetan. Se confirma con resonancia, hemocultivos y biopsia o punción guiada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 47

Tratamiento ATB de una osteomielitis de cadera en niño de 10 años:

A Cefazolina Cefa pq no tenia factores de riesgo a sarm, como tto empírico (decía específicamente empírico la pregunta, lo mejor es partir asumiendo que es SAMR como es una infección grave con Vanco) b. Vancomicina
C Ampicilina
C Staphylococcus aureus
D Streptococcus pneumoniae
E Escherichia coli

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Cefazolina Cefa pq no tenia factores de riesgo a sarm, como tto empírico (decía específicamente empírico la pregunta, lo mejor es partir asumiendo que es SAMR como es una infección grave con Vanco) b. Vancomicina (opción A).

▶ VER CLASE 4.02.1.005 Lumbago mecánico

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Traumatología 12.11 · Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis
Traumatología 12.15 · Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- Lumbago mecánico: el más frecuente; dolor que aumenta con el movimiento y cede con el reposo, por debilidad de musculatura axial; sin irradiación bajo la rodilla.

- Diagnóstico clínico: descartar banderas rojas (edad >50 o <20, cáncer, fiebre, baja de peso, trauma mayor, déficit neurológico, anestesia en silla de montar o alteración esfinteriana). Sin alarma no se piden imágenes.
- Dolor inflamatorio (mejora con ejercicio, empeora con reposo, rigidez matinal prolongada) orienta a espondiloartritis.
- Tratamiento: AINE o paracetamol, calor local, educación y mantener la actividad; evitar reposo prolongado en cama; kinesioterapia y fortalecimiento de musculatura lumbar y abdominal cuando cede el dolor agudo.
- Evoluciona favorablemente en 4–6 semanas; imágenes si persiste >4–6 semanas pese a tratamiento o aparecen banderas rojas.
- Seguimiento completo en APS: control clínico, ejercicios de fortalecimiento y ergonomía para prevenir recurrencias.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 29

Un paciente de 40 años, oficinista, estuvo moviendo muebles durante 2 días, evolucionando luego con intenso dolor lumbar, que le impide realizar sus actividades. Al examen físico se aprecia muy adolorido, con dificultades para subirse a la camilla y para caminar, tiene IMC de 28 y se observa una contractura muscular a nivel lumbar, con dolor ante todos los movimientos de la columna lumbar, sin signos de irritación nerviosa. **Además de administrar analgésicos, la indicación más adecuada es:**

A Resonancia magnética nuclear
B Radiografía de columna lumbosacra
C Kinesioterapia motora por 10 días
D Reposo en cama por 5 días
E Reposo laboral por 3 días

Respuesta E. Es un lumbago mecánico agudo, sin signos de irritación nerviosa. Se maneja con analgesia y reposo relativo, no en cama, que aquí es un breve reposo laboral. La kinesioterapia se inicia cuando el dolor cede, para fortalecer la musculatura y evitar recurrencias, y no se piden imágenes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 95

Hombre de 45 años con lumbalgia mecánica de 5 días de evolución, sin irradiación, sin signos de alarma. EF: dolor a la palpación paravertebral lumbar, sin déficit neurológico. ¿Cuál es el manejo más adecuado? **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Analgesia (AINEs o paracetamol) + kinesioterapia activa; no reposo en cama
B Reposo absoluto por 7 días
C Cirugía de columna
D Infiltración epidural de corticoides
E Resonancia magnética urgente

Respuesta A. Lumbalgia mecánica aguda sin alarma: AINE por corto plazo, actividad física progresiva y kinesioterapia. El reposo en cama prolonga la incapacidad, y no hay indicación de imagen en la fase aguda.

▶ VER CLASE 4.02.1.006 Lumbociática radicular

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.15 · Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- Lumbociática: dolor lumbar irradiado a la pierna bajo la rodilla, habitualmente por hernia del núcleo pulposo; Lasègue positivo.
- L5 (hernia L4-L5): dolor al dorso del pie y ortejo mayor, debilidad de dorsiflexión del hallux, reflejos normales. S1 (L5-S1): planta y borde lateral del pie, debilidad de flexión plantar, aquiliano disminuido. L4: reflejo rotuliano disminuido.
- Urgencia: anestesia en silla de montar, retención urinaria o incontinencia (cauda equina) o déficit motor progresivo → derivación urgente y RM.
- Manejo inicial sin déficit: analgesia (AINE, paracetamol), mantenerse activo, sin reposo en cama, por 4–6 semanas.
- RM solo con banderas rojas o falla del tratamiento médico; cirugía si fracasa el manejo médico bien llevado o hay déficit neurológico agudo.
- Seguimiento: derivar a traumatología o neurocirugía si persiste o hay déficit.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 139

Un paciente de 60 años consulta por lumbago intenso de 2 semanas de evolución, asociado a disfunción eréctil, que no ha respondido al tratamiento con analgésicos orales. Al examen físico, presenta limitación a los movimientos de flexoextensión y flexión lateral de la columna lumbar, debido al dolor. Además, se objetiva anestesia de la zona perineal. El diagnóstico más probable corresponde a un síndrome: **El diagnóstico más probable corresponde a un síndrome:**

A Lumbociático
B Facetario lumbar
C De compresión medular
D Sacroilíaco
E De cauda equina

Respuesta E. Tanto la compresión del cono medular como la de la cauda equina se presentan con anestesia en silla de montar y disfunción sexual. De las opciones, la más razonable es el síndrome de cauda equina, porque la compresión medular clásica tiene compromiso motor y sensitivo sin tanta afectación pudenda.

▶ VER CLASE 4.02.1.007 Pie plano

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.14 · Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Pie plano flexible: el arco aparece al pararse en puntillas o con la extensión del hallux; es fisiológico en niños pequeños y suele corregirse con el crecimiento.
- Pie plano flexible asintomático: tranquilizar; no requiere plantillas ni zapatos ortopédicos (no cambian la evolución).
- Sospechar patológico si es rígido (no se forma arco en puntillas), doloroso, unilateral o progresivo: descartar coalición tarsal, astrágalo vertical u otras causas.
- Manejo inicial del sintomático: calzado adecuado, ejercicios de fortalecimiento, control de peso y analgesia.
- Derivar a traumatología infantil el pie plano rígido, doloroso, unilateral o progresivo.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 76

Recién nacido con pie equino varo bilateral (CTEV) detectado al nacimiento. ¿Cuál es la conducta más adecuada? **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Control en el próximo control de salud infantil

B Derivar a ortopedia infantil para inicio de método Ponseti

C Hospitalizar para cirugía inmediata

D Observación domiciliaria: se corrige solo

E Kinesiología ambulatoria y férulas

Respuesta B. Pie equino varo congénito: derivación urgente a ortopedia pediátrica para iniciar el método de Ponseti, con yesos seriados y tenotomía percutánea del Aquiles si hace falta. Debe comenzar en las primeras semanas de vida y es corregible con tratamiento precoz.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 159

Niño de 8 años con pie plano flexible asintomático. El arco plantar aparece al pararse en puntillas. No tiene dolor ni limitación funcional. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tranquilizar a los padres: pie plano flexible fisiológico, no requiere plantillas ni tratamiento

B Plantillas correctoras

C Derivar a ortopedia

D Fisioterapia intensiva

E Cirugía correctora

Respuesta A. El pie plano flexible (el arco se forma en puntillas) y asintomático es una variante normal que no requiere plantillas: no cambian la evolución. Se deriva solo si es rígido, doloroso, unilateral o progresivo, para descartar coalición tarsal u otras causas.

▶ VER CLASE 4.02.1.008 Síndrome de hombro doloroso

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.11 · Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis
Traumatología 12.15 · Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- Causa más común: síndrome de manguito rotador (supraespinoso) por pinzamiento subacromial y movimientos repetitivos; dolor nocturno al acostarse sobre el hombro.
- Examen: arco doloroso entre 60° y 120°, Neer y Hawkins positivos, Jobe evalúa supraespinoso; movilidad pasiva conservada. Ecografía es el examen más costo-efectivo si se requiere.
- Capsulitis adhesiva (hombro congelado): limitación activa y pasiva, fase dolorosa y luego rigidez; tratamiento con corticoides y kinesioterapia intensiva.
- Debilidad marcada o imposibilidad de elevar el brazo y cabeza humeral ascendida sugieren rotura completa del manguito.
- Tratamiento inicial: reposo relativo, AINE, frío y kinesioterapia motora.
- Seguimiento: derivar a traumatología si no responde, hay sospecha de rotura completa o capsulitis.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 82

Una paciente de 43 años, secretaria, consulta porque, desde hace dos semanas, presenta dolor en el hombro derecho, que es más intenso durante la noche y que empeora con los movimientos del mismo, por lo que ha ido limitando sus actividades normales. El dolor aumenta con la abducción y con la elevación del brazo derecho, por sobre el hombro. Al examen físico tiene movilidad completa del hombro, con dolor en las maniobras descritas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Capsulitis adhesiva de hombro

B Tendinopatía del manguito rotador

C Disyunción acromioclavicular

D Tendinopatía de la cabeza larga del bíceps braquial

E Hernia cervical con compresión radicular

Respuesta B. Es una tendinopatía del manguito rotador clásica. La capsulitis adhesiva tiene más dolor y una clara limitación de los movimientos, por el dolor y, en la última fase, por fibrosis. La tendinopatía bicipital da dolor en la cara anterior del hombro.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 127

Hombre de 55 años con dolor en el hombro derecho al elevar el brazo entre 60-120° (arco doloroso). Prueba de Neer y Hawkins positivas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Síndrome de pinzamiento subacromial (manguito rotador)

B Luxación glenohumeral

C Capsulitis adhesiva (hombro congelado)

D Artritis reumatoide de hombro

E Fractura de clavícula

Respuesta A. Arco doloroso de 60 a 120 grados con Neer y Hawkins positivos es un síndrome de pinzamiento subacromial, por tendinitis o desgarro del manguito rotador. Tratamiento: kinesioterapia y antiinflamatorios, con o sin corticoides locales.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 119

Una paciente de 58 años presenta dolor en el hombro derecho desde hace 4 meses, que aumenta con la actividad física. Refiere que es intenso, con EVA 6/10, empeorando en la noche. Al examen físico, la movilidad pasiva está conservada, pero presenta limitación en la movilidad activa, especialmente para elevar el brazo por encima del hombro y en los movimientos de rotación interna. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Artrosis acromioclavicular

B Artrosis glenohumeral

C Síndrome del manguito rotador

D Capsulitis adhesiva

E Tendinopatía bicipital

Respuesta C. Es un síndrome del manguito rotador clásico. La capsulitis adhesiva, en cambio, se caracteriza por la limitación tanto de la movilidad pasiva como de la activa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 68

Un hombre de 42 años presenta dolor en el hombro derecho, de dos semanas de evolución, que inició en relación a un partido de tenis y que limita sus actividades, en especial, los movimientos de abducción y elevación. Al examen físico tiene dolor a la palpación subacromial, con dolor a la abducción y elevación del hombro, que dificulta estos movimientos, por sobre 80°. Se solicitan radiografías de hombro, que muestran esclerosis del acromion y leve ascenso de la cabeza humeral. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A Tendinitis cálcica

B Pinzamiento subacromial

C Rotura completa del tendón del supraespinoso

D Capsulitis adhesiva

E Tendinitis bicipital

Respuesta C. Parece un síndrome del manguito rotador, pero el ascenso de la cabeza humeral orienta a la rotura del tendón del supraespinoso. La capsulitis adhesiva limitaría totalmente los movimientos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 101

Una paciente de 31 años, secretaria, consulta por dolor en el hombro derecho, que ha aumentado en el último tiempo. Ella refiere que es más intenso en la noche y que aparece especialmente al levantar el codo por sobre el hombro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Tendinitis del manguito rotador

B Hernia del núcleo pulposo cervical

C Artrosis glenohumeral

D Tendinitis de la cabeza larga del bíceps

E Capsulitis adhesiva de hombro

Respuesta A. Diagnóstico: Tendinitis del manguito rotador (opción A). Era una tendinitis del manguito rotador clásica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 126

Una paciente de 45 años presenta dolor en el hombro derecho, que es mayor en la noche y que presenta impotencia funcional, que dificulta sus actividades. Al examen físico presenta dolor a la flexión y a la abducción tanto activa, como pasiva, del hombro derecho. La conducta más adecuada es:

A AINES y reposo

B AINES y kinesioterapia

C Cabestrillo

D Infiltración con corticoides

E Cirugía

Respuesta B. Es un síndrome del manguito rotador. Probablemente esta evolucionando a una capsulitis adhesiva (dolor al movimiento pasivo). Se debe dar analgésicos y movilizar precozmente, para evitar la anquilosis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 141

Una paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes mellitus ambas en tratamiento farmacológico, consulta por dolor en hombro derecho de varios meses de evolución, el cual aumenta de intensidad en la noche, asociado a impotencia funcional. Al examen físico sin dolor a la movilización pasiva y con dolor a la abducción y rotación externa de hombro derecho. El diagnóstico más probable es:

A Tendinopatía bicipital
B Osteoartritis de hombro
C Tendinopatía deltoídea
D Tendinopatía del manguito rotador
E Disyunción acromioclavicular leve

Respuesta D. El dolor mayor en la noche es característico. Además es la causa más frecuente de dolor en el hombro.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 140

Una paciente de 58 años, consulta porque, desde hace una semana, presenta dolor en el hombro derecho, que es más intenso durante la noche y que empeora con los movimientos del mismo, por lo que ha limitado sus actividades normales. El dolor aumenta con la abducción y con la elevación sobre 90° del brazo derecho. Al examen físico tiene movilidad completa del hombro, con dolor en las maniobras descritas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Capsulitis adhesiva de hombro
B Patología del manguito rotador
C Artritis séptica
D Tendinopatía de la cabeza larga del bíceps braquial
E Artrosis de la articulación glenohumeral

Respuesta B. Diagnóstico: Patología del manguito rotador (opción B). Es un síndrome de manguito rotador clásico.

▶ VER CLASE 4.02.1.009 Tumores óseos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.13 · Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante dolor óseo sordo o nocturno persistente que no cede con reposo, aumento de volumen, fractura patológica con trauma mínimo o hallazgo radiológico; un «esguince» que no mejora obliga a radiografía.
- Diagnóstico orientado por edad, ubicación (epífisis, metáfisis, diáfisis) y aspecto radiológico.
- Signos de malignidad: bordes mal definidos, cortical rota, invasión de partes blandas, reacción perióstica compleja (sol naciente, triángulo de Codman, telas de cebolla).
- Benignos: osteocondroma (el más frecuente, bulto indoloro, observar); osteoma osteoide (dolor nocturno que cede con aspirina/AINE, nidus radiolúcido).
- Malignos: osteosarcoma (adolescente, metáfisis cerca de la rodilla); Ewing (niño, diáfisis o pelvis, telas de cebolla); células gigantes (adulto 40–50, epífisis). En adultos, las metástasis óseas son más frecuentes que los tumores primarios.
- Manejo inicial: analgesia, evitar carga si hay riesgo de fractura y derivar a centro especializado para RM, TAC de tórax y biopsia.

PREGUNTAS · 12

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 18

Sd compresión medular en paciente con Ca de próstata y Mtt ósea. **Estudio:**

A Rnm columna con gadolinio
B Mielografía
C Cintigrama óseo
D Radiografía columna
E TAC

Respuesta A. Ante la sospecha de compresión medular neoplásica, el estudio de elección es la resonancia magnética de columna completa con gadolinio, coordinada en paralelo con dexametasona EV en dosis altas, que se inicia de inmediato sin esperar la imagen.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 154

Un paciente de 15 años sufre una torsión de rodilla derecha, siendo diagnosticado de un esguince, por lo que se indica inmovilizador de rodilla. Sin embargo, no mejora luego de 10 días, sino que, por el contrario, el dolor ha ido en aumento y no responde bien a la analgesia con naproxeno y ketorolaco. Al examen físico, presenta dolor a los movimientos de flexoextensión de la rodilla y a la palpación en la zona proximal y medial de la tibia derecha, sin signo de bostezo al varo ni al valgo. Se solicita una radiografía de rodilla, que muestra aspecto heterogéneo de la tibia proximal, con reacción perióstica. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Osteosarcoma
B Fractura
C Osteomielitis
D Esguince severo de rodilla
E Hematoma en organización

Respuesta A. Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos. Aspecto heterogéneo de la metáfisis con reacción perióstica en un adolescente corresponde a un osteosarcoma.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 9

Un adolescente de 16 años presenta dolor en la rodilla derecha, luego de haberse golpeado. Al examen físico se palpa aumento de volumen de consistencia ósea, por lo que se solicita una radiografía, que muestra una lesión ósea herterogénea, ubicada en el extremo distal del fémur, con disrupción de la cortical y zonas líticas, con otras de aumento de la densidad. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A Osteocondroma
B Tumor de células gigantes
C Osteosarcoma
D Displasia ósea fibrosa
E Quiste óseo

Respuesta C. Tumor óseo de aspecto maligno. Por la ubicación y la edad es un osteosarcoma, que aparece en adolescentes y adultos mayores. El sarcoma de Ewing es diafisiario.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 94

Un paciente de 19 años, sin antecedentes, hace un mes sufre golpe contuso en rodilla izquierda mientras jugaba futbol, tras lo cual ha permanecido con dolor el cual ha aumentado en las últimas semana, asociado a aumento de volumen duro. Se solicita radiografía de rodilla que muestra lesión de gran tamaño en metáfisis y diáfisis de fémur, asociado a compromiso cortical. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A Sarcoma de Ewing
B Osteosarcoma
C Osteoma osteoide
D Sarcoma de partes blandas
E Tumor de células gigantes

Respuesta B. Por la edad es un osteosarcoma. El tumor de células gigantes es de los 40 a los 55 años. El sarcoma de Ewing es de localización diafisiaria, no metafisiaria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 39

Una mujer de 18 años presenta traumatismo en la rodilla derecha, siendo diagnosticada de esguince de rodilla, el que se maneja con reposo y antiinflamatorios. Evoluciona con dolor persistente, por lo que consulta nuevamente. Se solicita una radiografía de rodilla que muestra reacción perióstica y compromiso de partes blandas. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A Osteomielitis del fémur distal
B Osteosarcoma osteogénico
C Fractura del fémur distal, con callo óseo
D Osteocondroma
E Hematoma calcificado

Respuesta B. La reacción perióstica y el compromiso de partes blandas son clásicos de un tumor maligno, y por la edad lo más probable es un osteosarcoma. En el EUNACOM es frecuente que se dé el antecedente de un trauma aunque no tenga relación con el tumor, porque el golpe es lo que hace que el paciente se palpe la lesión.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 90

Un adolescente de 17 años presenta un golpe en la rodilla izquierda, evolucionando con dolor en la cara anterior de la rodilla, que es manejado con analgésicos, sin embargo, no responde adecuadamente, por lo que se solicita una radiografía de rodilla y pierna, que muestra discontinuidad de la cortical de la diáfisis de la tibia, calcificación de partes blandas, reacción perióstica triangular de 2 cm y algunas zonas osteoblásticas con otras osteolíticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Fractura en maduración
B Hematoma calcificado
C Osteomielitis aguda
D Tumor óseo maligno
E Condromalacia

Respuesta D. Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía. Cortical interrumpida, calcificación de partes blandas, reacción perióstica triangular y zonas osteoblásticas junto a otras osteolíticas indican un tumor óseo maligno.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 10 años consulta por dolor en el brazo. La radiografía muestra una lesión en la diáfisis del húmero, de aspecto heterogéneo, con rotura de la cortical y extensión a partes blandas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Osteosarcoma
B Sarcoma de Ewing
C Tumor de células gigantes
D Osteocondroma
E Enfermedad de Paget

Respuesta B. Un niño con una lesión maligna en la diáfisis es un sarcoma de Ewing hasta que se demuestre lo contrario. El osteosarcoma prefiere la metáfisis, el tumor de células gigantes es de adultos, el osteocondroma es benigno y el Paget es de adultos mayores.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 53

Una mujer de 17 años presenta traumatismo en la rodilla izquierda, siendo diagnos- ticada de esguince de rodilla, el que se maneja con reposo y antiinflamatorios. Evolucio- na con dolor persistente, por lo que consulta nuevamente. Se solicita una radiografía de rodilla que muestra reacción perióstica y compromiso de partes blandas. El diagnóstico más probable es:

A Osteomielitis del fémur distal
B Osteosarcoma osteogénico
C Fractura del fémur distal, con callo óseo
D Osteocondroma
E Hematoma en organización

Respuesta B. Diagnóstico: Osteosarcoma osteogénico (opción B). Es un osteosarcoma clásico, aunque la pregunta estaba horriblemente redactada. Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 160

Paciente con traumatismo de rodilla persistente; radiografía muestra reacción perióstica y aumento de densidad en tibia proximal. ¿Diagnóstico más probable?

A Fractura de estrés tibial
B Osteosarcoma
C Osteomielitis crónica
D Encondroma
E Quiste óseo simple

Respuesta B. Diagnóstico: Osteosarcoma (opción B). Osteosarcoma. Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 152

Un niño de 13 años consulta por dolor y aumento de volumen, en relación a la pierna izquierda, que ha ido en aumento y lo hace cojear. Tiene antecedente de traumatismo en la zona. Se solicitan una radiografía y una resonancia magnética nuclear, que se muestran a continuación: El diagnóstico más probable es:

A Osteocondroma
B Osteosarcoma
C Sarcoma de partes blandas
D Tumor de células gigantes
E Sarcoma de Ewing

Respuesta E. Es una pregunta difícil, pero que ya se había realizado antes y se trata de un sarcoma de Ewing clásico, especialmente por la edad (menores de 15 años es lo más frecuente, aunque incluso se ve en adultos jóvenes) y por localización diafisiaria. Eso sí, también podría ser un sarcoma de partes blandas (más frecuente desde los 15 años), pero la clara afectación ósea de la RMN y también de la Rx hace que la respuesta sea la E, sin dudarlo mucho.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 9

Adolescente de 15 años con dolor en la rodilla derecha de 3 meses de evolución. Refiere haber tenido un golpe previo que no mejora. Radiografía: masa osteolítica con reacción perióstica en triángulo de Codman en la metáfisis distal del fémur. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Fractura patológica
B Osteomielitis crónica
C Sarcoma de Ewing
D Osteosarcoma
E Condrosarcoma

Respuesta D. Osteosarcoma: masa osteolítica en METÁFISIS de huesos largos (fémur distal / tibia proximal) en adolescentes + triángulo de Codman (reacción perióstica) = osteosarcoma. El Sarcoma de Ewing ocurre en DIÁFISIS y produce patrón "cebolla". Ambos tratados con cirugía + quimioterapia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 161

Paciente con traumatismo de rodilla; radiografía muestra reacción perióstica, lisis cortical triangular y aumento de densidad en partes blandas. ¿Diagnóstico más probable?

A Metástasis ósea
B Linfoma óseo primario
C Condrosarcoma
D Osteomielitis aguda
E Tumor óseo maligno primario

Respuesta E. Diagnóstico: Tumor óseo maligno primario (opción E). Tumor óseo maligno primario. Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos.

Situaciones clínicas de urgencia

15 códigos

▶ VER CLASE | 4.02.2.001 | **Complicaciones de los traumatismos: sistémicas y vasculares** | DX ESPECÍFICO | TX INICIAL | SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Traumatología 12.3 · Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente
Traumatología 12.4 · Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome compartimental (horas): dolor desproporcionado que no cede con analgésicos, dolor al estiramiento pasivo (signo más precoz), compartimento tenso; la ausencia de pulso es tardía. Típico con yeso circular o trauma de alta energía.
- Conducta inmediata: retirar yeso y vendajes; si no mejora, fasciotomía urgente. Nunca yeso circular en fractura reciente.
- Embolia grasa (horas a 48 h, fracturas de huesos largos): distrés respiratorio, compromiso de conciencia y petequias en tórax, cuello y axilas; manejo de soporte.
- TEP (días): disnea súbita y dolor pleurítico; angioTAC (el dímero D no sirve en el traumatizado); trombólisis si hay shock. Prevenir con tromboprofilaxis y movilización.
- Lesión vascular: 6 P (dolor, palidez, ausencia de pulsos, parestesias, parálisis, frialdad) y hemorragia pulsátil; compresión directa, torniquete solo si es exanguinante; derivar a cirugía vascular.
- Shock hipovolémico en fracturas de fémur (hasta 1,5 L) y pelvis: ABC y reposición de volumen. Seguimiento: derivar.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 131

Una paciente de 62 años sufre una caída a nivel, sufriendo una fractura del extremo distal del radio izquierdo, la que es manejada ortopédicamente, con un yeso braquiopalmar. A las 5 horas, evoluciona con intenso dolor, EVA 10/10, que no responde a la analgesia y se asocia a dificultades para mover los dedos. Al examen físico, se objetivan dedos con llene capilar enlentecido. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Síndrome de dolor locorregional complejo
B Lesión de la arteria radial
C Trombosis venosa profunda
D Compresión del nervio mediano
E Síndrome compartimental

Respuesta E. Dolor intenso que no responde a analgesia a pocas horas del yeso, con dificultad para mover los dedos y llene capilar enlentecido, es un síndrome compartimental.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 131

Una paciente de 62 años sufre una caída a nivel, con una fractura del extremo distal del radio izquierdo, que es manejada ortopédicamente con un yeso braquiopalmar. A las 5 horas evoluciona con dolor intenso, EVA 10/10, que no responde a la analgesia y se asocia a dificultad para mover los dedos. Al examen físico, los dedos tienen llene capilar enlentecido. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Síndrome de dolor locorregional complejo
B Lesión de la arteria radial
C Trombosis venosa profunda
D Compresión del nervio mediano
E Síndrome compartimental

Respuesta E. Dolor desproporcionado que no cede con analgesia, dificultad para mover los dedos y llene capilar lento pocas horas después de enyesar una fractura son un síndrome compartimental. Se debe abrir o retirar el yeso de inmediato y, si no mejora, fasciotomía.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente con fractura de fémur tratada hace tres días presenta en forma súbita disnea intensa y desaturación. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen de elección?**

A Embolia grasa; dímero D
B Tromboembolismo pulmonar; angiotac de tórax
C Tromboembolismo pulmonar; dímero D
D Síndrome compartimental; fasciotomía inmediata
E Neumonía aspirativa; radiografía de tórax

Respuesta B. El TEP aparece días después de una fractura, con disnea o dolor torácico súbito, y el examen de elección es el angiotac de tórax. El dímero D no es útil porque la fractura ya lo eleva. La embolia grasa aparece en las primeras horas, con tríada de distrés, compromiso de conciencia y petequias.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 55 años consulta 2 meses después de una fractura de muñeca tratada con yeso. Refiere dolor quemante en la mano, que se agrava con el roce de la ropa y al mover los dedos. Tiene la piel de la mano brillante, con cambios de color y de vello, y las uñas frágiles. La radiografía muestra osteoporosis moteada. No hay fiebre ni lesión de la piel. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Síndrome compartimental agudo
B Distrofia simpático refleja
C Contractura isquémica de Volkmann
D Osteomielitis
E Trombosis venosa profunda

Respuesta B. Dolor urente con alodinia, cambios tróficos y osteoporosis moteada semanas a meses después de la fractura es una distrofia simpático refleja, o síndrome de dolor regional complejo. El síndrome compartimental aparece en horas y la contractura de Volkmann se caracteriza por la mano en garra.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 52

Un paciente de 27 años sufre una fractura cerrada de antebrazo, que es manejada con un valva de yeso braquiopalmar. A las 5 horas presenta aumento del dolor y edema de la extremidad. El diagnóstico más probable es:

A Trombosis venosa profunda
B Síndrome compartimental
C Distrofia simpático refleja
D Alergia al yeso
E Síndrome de túne carpiano agudo

Respuesta B. Por el corto tiempo de evolución y el dolor es síndrome compartimental. Además es clásico de las Fx de antebrazo. Falta información

▶ VER CLASE 4.02.2.002 Disyunción-fractura del niño

DX SOSPECHA TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.14 · Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- En el niño, la fisis (cartílago de crecimiento) es más débil que los ligamentos: un trauma que en el adulto da esguince puede dar disyunción epifisaria.
- Sospechar ante dolor e impotencia funcional con dolor a la palpación sobre la fisis tras trauma, aunque la radiografía sea normal.
- Clasificación de Salter-Harris: I (solo fisis), II (fisis y metáfisis, la más frecuente), III (fisis y epífisis), IV (atraviesa metáfisis, fisis y epífisis), V (compresión de la fisis).
- Tipos I y II no desplazados: inmovilización con yeso o valva 3–4 semanas; también fracturas en rodete (torus) y en tallo verde se tratan con inmovilización.
- Tipos III, IV y V, desplazadas o intraarticulares: derivar a traumatología infantil (reducción anatómica) por riesgo de detención del crecimiento y deformidad.
- Seguimiento: control clínico y radiológico hasta consolidar y vigilar dismetría o deformidad angular; pensar en maltrato si el mecanismo no concuerda.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 178

Niño de 12 años, obeso, refiere dolor de 3 meses en la cadera izquierda y claudicación progresiva que actualmente le impide la marcha. Al examen físico presenta dolor a la rotación interna y externa de la cadera izquierda. La radiografía AP de pelvis y caderas muestra desplazamiento posteroinferior de la epífisis femoral proximal izquierda respecto de la metáfisis, con ensanchamiento de la fisis. **¿Cuál es el diagnóstico?**

A Displasia del desarrollo de la cadera
B Epifisiolisis
C Fractura del cuello del fémur
D Luxación de la cadera izquierda
E Necrosis avascular de la cabeza del fémur

Respuesta B. Adolescente obeso con dolor de cadera o rodilla, claudicación y deslizamiento de la epífisis femoral sobre la metáfisis es una epifisiolisis (disyunción a través de la fisis). Se suspende la carga y se deriva para fijación in situ urgente; no se intenta reducir. La necrosis avascular es su complicación.

▶ VER CLASE 4.02.2.003 Esguince grado1 (acromioclavicular, dedos, rodilla y tobillo)

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Traumatología 12.7 · Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince
Traumatología 12.9 · Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles

QUÉ HAY QUE SABER

- Esguince: lesión ligamentosa; grado I distensión leve con dolor sin equimosis ni inestabilidad; II rotura parcial con equimosis; III rotura total con inestabilidad.
- Tobillo: reglas de Ottawa; pedir radiografía si hay dolor en borde posterior o punta de maléolos, base del 5° metatarsiano o navicular, o incapacidad de dar 4 pasos. Si no cumple, no requiere radiografía.
- Rodilla: grado I del colateral medial con dolor al valgo sin bostezo y tope firme; Lachman y cajón negativos. Acromioclavicular grado I: dolor local sin desplazamiento de la clavícula. Dedos: dolor en la interfalángica sin inestabilidad.
- Tratamiento: reposo relativo, hielo, compresión, elevación (RICE), AINE, movilización y carga precoz según tolerancia; sin inmovilización rígida (cabestrillo breve en acromioclavicular, sindactilia en dedos).
- Rehabilitación propioceptiva y fortalecimiento para evitar recidiva e inestabilidad crónica.
- Seguimiento completo: control en 1–2 semanas; si no mejora o el dolor aumenta, reevaluar con radiografía (fractura, tumor) o derivar.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un deportista de cuarenta años va corriendo y siente súbitamente como una pedrada intensa en el talón. No puede caminar. La maniobra de Thompson está alterada. **¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?**

A Esguince de tobillo grado tres; inmovilización con bota removible
B Rotura del tendón de Aquiles; cirugía urgente
C Rotura del tendón de Aquiles; inmovilización con yeso
D Fractura de calcáneo; radiografía de pie
E Desgarro muscular de gemelos; RICE y AINEs

Respuesta B. El dolor súbito en el talón, como una pedrada, al correr, más la maniobra de Thompson alterada, es el cuadro clásico de rotura del tendón de Aquiles. El libro indica cirugía. El esguince de tobillo afecta los ligamentos laterales y no altera la maniobra de Thompson.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 24 años se dobla el tobillo derecho hacia adentro jugando básquetbol hace 3 horas. Pudo caminar 4 pasos al llegar al SAPU. Al examen: leve aumento de volumen y dolor a la palpación del ligamento peroneoastragalino anterior, sin dolor en el borde posterior ni la punta de los maléolos, ni en la base del quinto metatarsiano ni en el navicular. Cajón anterior negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Radiografía de tobillo AP, lateral y mortaja antes de indicar tratamiento
B Bota de yeso por 4 semanas
C Reposo relativo, hielo, compresión y elevación, analgesia, carga precoz según tolerancia y ejercicios de propiocepción
D Resonancia magnética para evaluar rotura ligamentosa
E Derivación a traumatología para reparación quirúrgica

Respuesta C. Por las reglas de tobillo de Ottawa (camina 4 pasos, sin dolor óseo en maléolos, quinto metatarsiano ni navicular) no requiere radiografía. Es un esguince grado 1 del peroneoastragalino anterior, que se trata con medidas RICE, analgesia, movilización y carga precoz y rehabilitación propioceptiva; el yeso no está indicado.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 29 años recibe un golpe en la cara externa de la rodilla derecha jugando fútbol hace 1 día. Camina con leve cojera. Al examen: dolor a la palpación del ligamento colateral medial, sin derrame articular. El bostezo en valgo a 30 grados de flexión es doloroso pero sin apertura de la interlínea y con tope firme. Lachman y cajón anterior negativos, sin bloqueo. **¿Cuál es el diagnóstico y el manejo más adecuados?**

A Esguince grado 3 del colateral medial; cirugía de reparación
B Esguince grado 1 del colateral medial; frío local, analgesia, carga según tolerancia y fortalecimiento precoz, sin inmovilización rígida
C Rotura de menisco medial; resonancia magnética urgente
D Rotura del ligamento cruzado anterior; derivar a cirugía artroscópica
E Esguince grado 2; yeso inguinopédico por 6 semanas

Respuesta B. En el esguince grado 1 hay distensión de fibras sin pérdida de continuidad: dolor a la palpación y al estrés, pero sin laxitud y con tope firme. Se maneja con frío, analgesia, carga precoz y ejercicios, sin inmovilización rígida. La laxitud con tope firme sería grado 2 y sin tope, grado 3.

▶ VER CLASE 4.02.2.004 Fractura de cadera

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Traumatología 12.10 · Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en adulto mayor con caída de propia altura, dolor inguinal e imposibilidad de apoyar; extremidad acortada y en rotación externa (posición impúdica).
- Estudio: radiografía de pelvis AP y cadera AP y axial (no resonancia ni radiografía de fémur como primer examen).

- Manejo inicial: analgesia, inmovilización, hidratación, prevención de úlceras por presión y TEV; tracción de partes blandas mientras espera cirugía si corresponde.
- Tratamiento siempre quirúrgico y precoz (24–48 h): prótesis en fractura de cuello femoral desplazada en mayor de 65 años; tornillos canulados si no desplazada o joven; tornillo dinámico en intertrocantérica.
- Diferencial: luxación posterior de cadera (joven, choque frontal, aducción y rotación interna, lesión del ciático) se reduce cerrada bajo anestesia.
- Mortalidad alta (hasta 50 % a 2 años): derivar a traumatología y tratar la osteoporosis subyacente tras la fractura.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 50

Una paciente de 80 años sufrió una caída a nivel, luego de la cual no pudo levantarse, presentando mucho dolor. Al examen físico presenta acortamiento de la extremidad inferior derecha, con ligera abducción y rotación externa, sin equimosis. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Esguince de cadera
B Fractura de cadera
C Luxación posterior de cadera
D Fractura de pelvis
E Fractura vertebral con lesión del plexo lumbar

Respuesta B. Caída a nivel en una adulta mayor con impotencia funcional y extremidad acortada, en rotación externa y leve abducción: fractura de cadera clásica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 10

Una paciente de 26 años, sin antecedentes, mientras iba como copiloto sufre accidente de tránsito, resultando con dolor en extremidad inferior derecha. Al ingreso con vía aérea permeable, respiración espontánea, sin sangramientos evidentes, presión arterial de 150/90, Glasgow 15, extremidad inferior derecha en posición púdica. **El diagnóstico más probable es:**

A Luxación anterior de cadera
B Fractura intertrocantérica
C Fractura de cuello femoral
D Luxación posterior de cadera
E Fractura de pelvis

Respuesta D. La posición púdica es característica de la luxación posterior. La fractura, en cambio, tiene posición impúdica: abducción, rotación externa y acortamiento.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 98

Un hombre protagoniza un accidente de tránsito, chocando de manera frontal, contra otro automóvil. Presenta intenso dolor en la cadera derecha, que le impide caminar. En su examen tiene una rotación fija hacia interno, con aducción del muslo. **El diagnóstico más probable es:**

A Fractura de cuello femoral
B Fractura de cotilo
C Esguince grado 3 de cadera
D Luxación anterior de cadera
E Luxación posterior de cadera

Respuesta E. Aducción y rotación interna fija tras un choque frontal es la posición púdica de la luxación posterior de cadera. La fractura de cuello femoral tiene posición impúdica, con rotación externa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 178

Niño de 12 años, obeso, refiere dolor de 3 meses en cadera izquierda y claudicación progresiva, que actualmente impide la marcha. Al examen físico presenta dolor a la rotación interna y externa de la cadera izquierda. Se realiza radiografía AP pelvis y caderas, que se muestra a continuación: El diagnóstico es: **El diagnóstico es:**

A Displasia del desarrollo de la cadera
B Epifisiolisis
C Fractura del cuello del fémur
D Luxacion de la Cadera izquierda
E Necrosis avascular de la cabeza del fémur

Respuesta B. Es una epifisiolisis de la cabeza femoral clásica: un adolescente con claudicación y dolor de cadera, asociada a sobrepeso y obesidad. Además se ve el signo del helado caído.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 72 años, que camina sin ayuda, tiene una fractura de cuello femoral desplazada. **¿Cuál es el tratamiento?**

A DHS o tornillo dinámico de cadera

B Prótesis de cadera

C Tornillo canulado y observar si hace necrosis

D Cirugía de Girdlestone

E Inmovilización y manejo conservador por la edad

Respuesta B. Fractura de cuello femoral, desplazada y en mayor de 65 años: las tres condiciones para indicar prótesis de entrada, por el alto riesgo de necrosis avascular. El tornillo dinámico es para fracturas intertrocantéricas, el Girdlestone para postrados, y la fractura de cadera siempre se opera.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 99

Un paciente de 26 años, sufre un accidente automovilístico de alta energía, como conductor. Llega a la urgencia entablillado y con hemodinamia estable. Destaca la extremidad inferior derecha en flexión y aducción, dolorosa, con imposibilidad de caminar. Se realiza radiografía anteroposterior de pelvis, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Fractura de la cabeza femoral derecha

B Fractura de zona posterior del cotilo derecho

C Luxofractura posterior de cadera derecha

D Fractura de pelvis inestable

E Fractura extracapsular de cadera derecha

Respuesta C. Está en posición púdica, clásica de la luxación posterior de cadera; y la radiografía muestra la luxación posterior derecha. No queda claro el rasgo de fractura.

▶ VER CLASE 4.02.2.005 Fractura de la muñeca

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.1 · Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización

QUÉ HAY QUE SABER

- Fractura de radio distal (Colles): adulto mayor que cae sobre la mano en extensión; deformidad en dorso de tenedor, equimosis y dolor a la compresión del radio distal; típica de hueso osteoporótico.
- En niños con fisis abierta el equivalente es la disyunción del radio distal. Fractura de escafoides: dolor en la tabaquera anatómica sin deformidad; la radiografía inicial puede ser normal.
- Confirmación: radiografía de muñeca AP y lateral (proyecciones de escafoides si se sospecha).
- Manejo inicial: examen neurovascular (nervio mediano), analgesia, valva de yeso antebraquiopalmar no circular, elevación y movilización de dedos.
- Sospecha de escafoides con radiografía normal: inmovilizar igual y repetir imagen en 10–14 días (riesgo de necrosis avascular y pseudoartrosis).
- Vigilar síndrome compartimental (dolor desproporcionado bajo el yeso: retirarlo). Seguimiento: derivar a traumatología; tratar la osteoporosis.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 141

Paciente de 70 años sufre una caída a nivel, con apoyo de la extremidad superior en extensión contra el suelo. Evoluciona con dolor en la muñeca que le impide moverla. Consulta al día siguiente con la muñeca deformada en "dorso de tenedor", equimosis palmar y dorsal, y dolor a la compresión del radio distal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Esguince de muñeca

B Fractura de la epífisis distal del radio

C Disyunción del extremo distal del radio

D Luxofractura de Monteggia

E Fractura de escafoides carpiano

Respuesta B. Adulto mayor que cae sobre la mano en extensión y presenta deformidad en dorso de tenedor tiene una fractura de radio distal con desplazamiento dorsal (Colles), típica de hueso osteoporótico. La disyunción ocurre en niños con fisis abierta; el escafoides duele en la tabaquera anatómica sin esta deformidad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 65

Una paciente de 65 años sufre caída a nivel, apoyando la mano derecha contra el suelo, en extensión de la extremidad. Evoluciona con dolor intenso en la muñeca, que le impide realizar movimientos. Al examen físico se aprecia deformidad de la muñeca y dolor epicrítico a la presión del radio distal. El diagnóstico más probable es:

A Fractura de escafoides
B Fractura de epifisis distal del radio
C Disyunción-fractura de radio distal
D Luxofractura de Monteggia
E Luxación de cúpula radial

Respuesta B. Es una mala pregunta: no hay duda de que es una fractura de radio distal, pero la clínica es insuficiente para distinguir entre la fractura de epífisis y la disyunción fractura. Sin embargo, “disyunción fractura” o “luxofractura” se usa más para las fracturas de Monteggia y Galeazzi, que no corresponden a este cuadro, por lo que dejaremos la B como correcta. Sin embargo, la fractura no necesariamente es de la epífisis y puede ser de la metáfisis por ejemplo, así que definitivamente es una mala...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 99

Un paciente de 28 años sufre una caída a nivel, cayendo sobre la mano izquierda, con extremidad superior izquierda en extensión. Al examen físico presenta dolor a la compresión axial del pulgar y al presionar la tabaquera anatómica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Fractura de la base de la primera falange proximal
B Fractura de escafoides
C Fractura perilunar
D Fractura del extremo distal del radio
E Esguince de la primera articulación metacarpofalángica

Respuesta B. Diagnóstico: Fractura de escafoides (opción B). Es un fractura de escafoides clásica.

▶ VER CLASE 4.02.2.006 Fractura inestable de la pelvis

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.5 · Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en politraumatizado por mecanismo de alta energía con dolor pélvico, inestabilidad y shock; la fractura en libro abierto (sínfisis) sangra por plexos venosos y es causa principal de muerte precoz.
- Radiografía de pelvis AP en la evaluación primaria; no repetir maniobras de estabilidad (rompen coágulos).
- Manejo inicial: ABCDE, dos vías gruesas, volumen y transfusión; cerrar la pelvis con sábana pélvica sobre los trocánteres mayores o faja pélvica; no perder tiempo en imágenes si hay shock.
- Lesión uretral: sangre en el meato, próstata flotante, hematoma perineal → prohibida la sonda Foley; uretrocistografía retrógrada y cistostomía suprapúbica.
- Tacto rectal y vaginal para descartar fractura expuesta a mucosa (antibióticos y cirugía urgente).
- Seguimiento: derivar de urgencia a centro con traumatología (fijación externa, angioembolización).

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 26

Paciente de 30 años sufre una caída desde 15 metros de altura, golpeándose contra el suelo. Al examen físico está orientado, con frecuencia cardíaca de 80 y presión arterial de 120/80, con mucho dolor a la compresión de la pelvis, mayor a izquierda. Se solicita una radiografía de pelvis que muestra una fractura pélvica. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Pasar una sonda Foley
B Indicar reposo con una hamaca o sábana pélvica
C Administrar antibióticos
D Realizar cirugía de inmediato
E Solicitar ecografía de abdomen y pelvis

Respuesta B. Frente a una fractura de pelvis, lo primero es estabilizar el anillo pélvico externamente, con un tutor externo o, si no está disponible, una sábana o hamaca pélvica, para limitar la hemorragia venosa. La sonda Foley se pospone hasta descartar una lesión uretral asociada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 51

Un paciente de 28 años sufre un accidente de tránsito de alta intensidad, por lo que es trasladado al servicio de urgencia. En la evaluación inicial tiene presión arterial de 90/50 mmHg, frecuencia cardíaca 115x' y se aprecia adolorido. Al examen, además, tiene dolor intenso al comprimir la zona iliaca y púbica y al realizar movimientos de rotación de la pelvis. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Instalar sonda Foley

B Realizar laparotomía exploradora

C Realizar radiografía AP de pelvis

D Instalar sábana pélvica

E Solicitar TAC de pelvis

Respuesta D. Tiene una probable fractura de pelvis, pero por tener compromiso hemodinámico, lo más urgente es poner una vía venosa, administrar fluidos y estabilizar la pelvis (por ejemplo con una sábana pélvica).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 30 años, hemodinámicamente estable, ingresa tras un accidente de tránsito con una fractura de pelvis confirmada por radiografía. Al hacer el tacto rectal, el dedo sale con sangre y se palpa un fragmento óseo que protruye a la luz del recto. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Manejo ortopédico con reposo en cama

B Antibióticos y cirugía de urgencia

C Instalar una sonda Foley

D Observación y repetir el tacto rectal en 24 horas

E Solo analgesia y control en el policlínico

Respuesta B. El tacto rectal y vaginal busca una fractura expuesta hacia la mucosa. Si la fractura comunica con el recto, es una fractura expuesta de la pelvis y requiere antibióticos y cirugía de urgencia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 34

Mujer con fractura de pelvis inestable con shock: conducta de reanimación inicial:

A SF 0,9% yo puse esto u.u

B Cerrar anillo pélvico (pienso que es esta porque es lo único que disminuirá el sangrado que le está matando) Pero preguntaban por manejo del shock inicial

C Tratamientos específicos de la causa

D Reparación arterial

E Amoxicilina

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: SF 0,9% yo puse esto u.u (opción A).

▶ VER CLASE 4.02.2.007 Fracturas de diáfisis y metáfisis

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Traumatología 12.1 · Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización
Traumatología 12.6 · Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa
Traumatología 12.7 · Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince

QUÉ HAY QUE SABER

- Clínica de fractura: dolor intenso que aumenta al movilizar, deformidad, impotencia funcional, crepitación y equimosis.
- Confirmación: radiografía en dos proyecciones (AP y lateral) que incluya articulaciones proximal y distal; TAC si hay rasgo articular.
- Asociaciones: diáfisis humeral → nervio radial (mano caída); supracondílea de húmero → mediano y arteria braquial; diáfisis de tibia → síndrome compartimental; fémur → shock hipovolémico.
- Manejo inicial: ABC primero, examen neurovascular antes y después, alinear con tracción suave, inmovilizar con férula o valva no circular que incluya articulaciones vecinas y analgesia.
- Indicación quirúrgica: fémur y tibia diafisarias, desplazadas o irreductibles, conminutas, segmentarias, intraarticulares, expuestas o inestables.
- Seguimiento: derivar a traumatología; vigilar retardo de consolidación, pseudoartrosis (movilidad indolora del foco) y consolidación viciosa.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 30 años llega a urgencias tras un accidente de tránsito con dolor e impotencia funcional en el antebrazo derecho, con deformidad visible y crepitación al examen. **¿Cuál es el diagnóstico y el estudio inicial?**

A Contusión de antebrazo; ecografía de partes blandas

B Fractura de antebrazo; radiografías anteroposterior y lateral

C Luxación de codo; TAC de antebrazo

D Fractura de antebrazo; solo radiografía anteroposterior

E Contusión grave; solo analgesia y observación

Respuesta B. Dolor, deformidad, impotencia funcional y crepitación son la clínica clásica de fractura. Se confirma con radiografías en dos proyecciones, anteroposterior y lateral. Una sola proyección no basta.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente con fractura de tibia en yeso desde hace cuatro meses sigue con dolor leve en el foco de fractura. La radiografía muestra callo óseo en formación pero sin terminar de consolidar. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?**

A Pseudoartrosis; cirugía para remover partes blandas

B Retraso de consolidación; mejorar la inmovilización

C Consolidación viciosa; cirugía de refractura

D Pseudoartrosis atrófica; tratamiento de la mala irrigación

E Osteomielitis; antibióticos endovenosos

Respuesta B. El retraso de consolidación se presenta con dolor persistente más allá del tiempo normal y callo en maduración en la radiografía. El tratamiento es mejorar la inmovilización, que era la causa. La pseudoartrosis tiene movilidad anormal y poco dolor.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 28 años es atropellado. Llega con dolor intenso y deformidad del muslo derecho. Presión arterial 82/50 mmHg, frecuencia cardíaca 128 por minuto, piel fría y sudorosa. Está consciente, con vía aérea permeable. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Radiografías de fémur AP y lateral antes de cualquier otra medida

B Cirugía inmediata de osteosíntesis sin otra evaluación

C Manejo ABC con reposición de volumen e inmovilización provisoria

D Yeso circular e indicar control ambulatorio

E Analgesia oral y observación

Respuesta C. Un fémur puede perder hasta 1,5 litros de sangre, y este paciente está en shock hipovolémico. Primero va el ABC: reposición de volumen y control de la hemorragia, con inmovilización provisoria. La radiografía y la cirugía vienen después de estabilizarlo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente tiene una fractura de pierna con el hueso muy desplazado, irreductible por maniobra ortopédica, y con múltiples fragmentos conminutos. **¿Cuál es la conducta?**

A Inmovilización con yeso e indicar control en dos semanas

B Cirugía con reducción y osteosíntesis

C Tracción continua por cuatro semanas y luego yeso

D Observación porque las fracturas de pierna siempre consolidan solas

E Inmovilización con órtesis funcional por seis semanas

Respuesta B. Una fractura muy desplazada, irreductible y conminuta tiene indicación quirúrgica clara: reducción y osteosíntesis. Con yeso solo hay alto riesgo de pseudoartrosis y consolidación viciosa.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 55 años, fumador y diabético, tuvo una fractura de tibia manejada con yeso hace 8 meses. Consulta porque nota que "se mueve" el sitio de la fractura, casi sin dolor. La radiografía muestra los extremos óseos adelgazados, redondeados, en punta de lápiz. **¿Cuál es el diagnóstico y la causa más probable?**

A Retardo de consolidación; inmovilización inadecuada

B Pseudoartrosis hipertrófica; mala inmovilización

C Pseudoartrosis atrófica; mala irrigación

D Consolidación viciosa; mala reducción inicial

E Consolidación normal; no requiere estudio

Respuesta C. La movilidad anormal casi sin dolor orienta a pseudoartrosis. Los extremos adelgazados en punta de lápiz corresponden a la forma atrófica, por mala irrigación sanguínea, y el tabaquismo y la diabetes la favorecen. La hipertrófica se ve con extremos ensanchados en pata de elefante.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 32 años sufre un accidente de moto y llega con dolor intenso en el muslo derecho, deformidad del eje de la extremidad y crepitación. No puede mover la pierna. Los pulsos distales están presentes. **¿Cuál es el estudio y el tratamiento más adecuados?**

A Radiografía de fémur AP y lateral con cadera y rodilla; cirugía con clavo intramedular

B Radiografía solo de la zona del dolor; yeso por seis semanas

C Resonancia magnética de muslo; reposo y analgesia

D Solo radiografía de pelvis; manejo ortopédico

E Ecografía de partes blandas; vendaje compresivo

Respuesta A. La fractura de fémur se confirma con radiografía AP y lateral que incluya las articulaciones proximal y distal, y su tratamiento es siempre quirúrgico, habitualmente con clavo intramedular o placa. El manejo ortopédico no vence la fuerza muscular y termina en consolidación viciosa o pseudoartrosis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 100

Un paciente sufre una caída a nivel, con golpe en el hombro derecho, evolucionando con dolor e impotencia funcional. Se realizan radiografías de hombro, una de las que se muestra a continuación: FOTO (Radiografía AP de hombro, con fractura del tercio medio de la clavícula derecha, con ligero desplazamiento, sin conminución) ¿Qué tipo de inmovilización es la más adecuada?

A Vendaje axial de hombro

B Vendaje en ocho

C Yeso Velpeau

D Yeso toracobraquial

E Cabestrillo

Respuesta E. , ¿B?. El cabestrillo y el vendaje en 8 son los más usados en las fracturas del tercio medio de clavícula. Sin embargo, también se pueden usar otros tipos de inmovilización, según la valoración por el especialista. El vendaje en 8 se asocia a mayores molestias, por compresión cutánea y del complejo neurovascular axilar, así que el cabestrillo suele ser lo más recomendado. De todos, modos, es una pregunta de especialista.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 133

Caída en paracaídas, se observa deformidad en valgo: a. Fractura platillo tibial lateral (esta, confirmado por un TMT)

B Fractura cóndilo medial fémur

C Rotura menisco anterior

D Ligamento cruzado anterior

D Laparotomía exploratoria

E Cirugía laparoscópica

Respuesta A. La alternativa correcta es la A ().

▶ VER CLASE 4.02.2.008

Fracturas expuestas

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.2 · Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente

QUÉ HAY QUE SABER

- Toda herida cercana a una fractura es expuesta hasta demostrar lo contrario; riesgo principal: infección y osteomielitis.
- Gustilo-Anderson: I herida <1 cm; II 1–10 cm; III >10 cm o alta energía (IIIA cobertura adecuada, IIIB requiere colgajo, IIIC lesión arterial). Arma de fuego siempre grado III.
- Manejo inicial: ABC, lavado abundante con suero fisiológico, antibiótico EV en la primera hora, analgesia y profilaxis antitetánica según esquema.
- Antibiótico: grado I cefazolina; II cefazolina + gentamicina; III cefazolina + gentamicina + clindamicina (cobertura de anaerobios).
- Antes del traslado: no suturar, cubrir con apósito estéril, valva de yeso larga y abierta (no yeso circular), revisar pulsos y nervios antes y después.
- Seguimiento: derivar de urgencia para aseo quirúrgico, desbridamiento y fijación (externa frecuente en grado III).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente tiene fractura de pierna expuesta grado 1 de Gustilo: herida menor de un centímetro, baja energía, contaminación mínima. **¿Cuál es el antibiótico endovenoso inicial?**

A Cefazolina

B Amikacina más cefazolina

C Cefazolina más amikacina más clindamicina

D Metronidazol intravenoso

E Amoxicilina clavulánico oral

Respuesta A. El grado I requiere cobertura para gram positivos, especialmente estafilococo aureus, y la cefazolina es la cefalosporina de primera línea. La amikacina se agrega en el grado II, y la triple combinación es del grado III. En la fractura expuesta el tratamiento es endovenoso.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 34 años recibe un disparo en la pierna izquierda. Hay un orificio de 1 cm en la cara anterior de la tibia, sin hueso visible, y la radiografía muestra una fractura diafisaria. Tiene pulsos distales presentes y está hemodinámicamente estable. **¿Cómo se clasifica y qué esquema antibiótico corresponde?**

A Grado I; cefazolina sola

B Grado II; cefazolina más gentamicina

C Grado III; cefazolina, gentamicina y clindamicina

D No es fractura expuesta; yeso circular y control

E Grado III; solo metronidazol

Respuesta C. Toda fractura por arma de fuego se clasifica automáticamente como grado III, aunque la herida sea pequeña. Corresponde triple cobertura: cefazolina, gentamicina y clindamicina, además del aseo y el traslado con valva abierta.

▶ VER CLASE 4.02.2.009 Heridas de la mano no complicadas

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.18 · Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

QUÉ HAY QUE SABER

- Explorar siempre la función de tendones flexores y extensores de cada dedo contra resistencia, la sensibilidad de los pulpejos (discriminación de 2 puntos) y la perfusión (llene capilar).
- Herida no complicada: limpia, reciente, sin compromiso de tendones, nervios digitales, vasos ni articulación ni cuerpo extraño; se maneja en urgencia.
- Tratamiento: aseo, exploración bajo anestesia local, hemostasia por compresión y sutura con puntos simples de nylon; no requiere antibiótico.
- Profilaxis antitetánica: herida limpia con esquema completo solo si última dosis >10 años; sucia si >5 años; esquema incompleto o desconocido con herida sucia: vacuna + inmunoglobulina.
- Mordeduras de la mano: lavado a presión, no suturar, amoxicilina/clavulánico; evaluar profilaxis antirrábica.
- Seguimiento completo: control de la herida a las 48–72 h y retiro de puntos a los 10–14 días; derivar si aparece déficit tendinoso o nervioso.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años se corta la palma de la mano con un cuchillo de cocina hace 2 horas. Herida lineal limpia de 2 cm en la eminencia tenar, sangrado controlado con compresión. La flexión y extensión de todos los dedos contra resistencia es normal, la sensibilidad de los pulpejos (discriminación de 2 puntos) está conservada y el llene capilar es normal. Vacuna antitetánica completa hace 4 años. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Vacuna antitetánica y gammaglobulina antitetánica

B Derivar a cirugía de mano para exploración en pabellón

C Dejar la herida abierta para cierre por segunda intención

D Cierre con puntos y cefazolina oral por 7 días

E Aseo, exploración bajo anestesia local y sutura con puntos simples de nylon

Respuesta E. Una herida limpia de la mano, reciente, con tendones, nervios digitales y perfusión indemnes es una herida no complicada: se maneja en urgencia con aseo, exploración bajo anestesia local y sutura. No requiere antibióticos. Con vacuna completa hace menos de 5 años no necesita refuerzo antitetánico.

▶ VER CLASE 4.02.2.010 Lesiones de los nervios periféricos

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.4 · Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico clínico: déficit motor y sensitivo distal tras fractura o luxación; examinar antes y después de reducir o inmovilizar.
- Radial: fractura de diáfisis humeral, no extiende muñeca ni dedos, hipoestesia posterior. Axilar: luxación anterior de hombro, no abduce, pierde sensibilidad en parche deltoideo.
- Mediano: supracondílea de húmero, no flecta dedos 1–3. Cubital: fractura medial de codo, no flecta dedos 4 y 5. Ciático: luxación posterior de cadera, no flecta rodilla ni dorsiflexiona.
- Compresiones sin fractura: parálisis del sábado (radial), luna de miel (plexo braquial); peroneo común en la cabeza del peroné por yesos o tracción.
- Déficit parcial (neuroapraxia): observar, suele recuperarse. Déficit total o tras herida penetrante: exploración quirúrgica.
- Manejo inicial: inmovilizar, analgesia y derivar a traumatología.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 103

Un paciente sufre una fractura de húmero derecho, que es manejada mediante reducción quirúrgica y osteosíntesis. Al quinto día, evoluciona con parestesias y dolor de la extremidad, asociada a imposibilidad de extender la muñeca. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Síndrome compartimental

B Compresión del nervio mediano

C Lesión del nervio musculocutáneo

D Atrapamiento del nervio cubital

E Lesión del nervio radial

Respuesta E. Es la afectación clásica del nervio radial, que está en estrecho contacto con la diáfisis humeral. No poder extender la muñeca es la clave.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 173

Una paciente sufre una fractura de la diáfisis humeral derecha, la que es manejada mediante cirugía, con osteosíntesis con placa. A las 24 horas, evoluciona con dolor en el sitio de la fractura, asociada a imposibilidad de extender la muñeca derecha. Mantiene la flexión activa de los dedos de esa mano. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trombosis de la arteria braquial
B Neurapraxia del nervio radial
C Desplazamiento de la placa
D Síndrome compartimental
E Lesión del plexo braquial

Respuesta B. El dolor en la zona orienta a un síndrome compartimental, pero solo se describe la afectación del nervio radial, sin otras alteraciones, por lo que lo más probable es una neurapraxia del radial.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 70

Paciente de 35 años sufre traumatismo en la región posterior del húmero. Al examen: no puede extender la muñeca ni los dedos (caída de muñeca). ¿Qué nervio fue lesionado? **¿Qué nervio fue lesionado?**

A Nervio radial (en canal de torsión)
B Nervio cubital
C Nervio mediano
D Nervio musculocutáneo
E Nervio axilar

Respuesta A. Fractura de húmero con caída de muñeca es una lesión del nervio radial en el canal de torsión, o surco espiral. Inerva los extensores de la muñeca y de los dedos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 41

Una paciente de 35 años, sin antecedentes, sufre fractura de diáfisis humeral izquierda, evolucionando posteriormente con hipostesia del dorso de dicha mano, asociado a imposibilidad de realizar extensión de muñeca y falanges. ¿La estructura más probablemente dañada en este caso es? **¿La estructura más probablemente dañada en este caso es?**

A Nervio mediano
B Nervio ulnar
C Nervio radial
D Nervio axilar
E Nervio musculocutáneo

Respuesta C. Fractura de la diáfisis humeral con hipoestesia del dorso de la mano e imposibilidad de extender la muñeca y las falanges corresponde al nervio radial. Es una pregunta clásica de libro.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 112

Un paciente de 43 años consulta por dolor y parestesias en el dedo meñique y anular derechos, que inició hace 3 años y ha progresado, aumentando su intensidad. Relata que, en la noche, los síntomas suelen ser más intensos y que actualmente tiene parestesias continuas en el meñique. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Síndrome del túnel carpiano
B Contractura de Dupuytren
C Radiculopatía C7
D Atrapamiento cubital
E Compresión del plexo braquial

Respuesta D. Diagnóstico: Atrapamiento cubital (opción D). Es un atrapamiento cubital clásico.

▶ VER CLASE `4.02.2.011` **Lesiones de partes blandas (contusiones, hematomas, desgarros)**

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Traumatología 12.8 · Lesiones de Rodilla: Meniscos, Ligamentos Cruzados y Colaterales & Dolor Patelofemoral
Traumatología 12.9 · Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles

QUÉ HAY QUE SABER

- Contusión: golpe directo sin herida; dolor, edema y equimosis sin signos de fractura; radiografía si hay alta energía o dolor muy invalidante.
- Tratamiento de contusión: AINE, frío local las primeras 48 h y luego calor, reposo relativo; pronóstico excelente.
- Hematoma: colección fluctuante, violácea; ecografía de apoyo. Conservador con frío, calor y AINE; drenaje quirúrgico si es muy grande, muy doloroso o infectado (calor, rubor, fiebre).
- Desgarro muscular: dolor súbito durante esfuerzo; RICE, AINE y rehabilitación progresiva.
- Rotura del tendón de Aquiles: «pedrada» en el talón al correr en adulto de mediana edad, Thompson alterado → derivar, no es esguince. Quiste de Baker roto simula TVP (antecedente de masa poplítea).

- Seguimiento completo: control clínico; reevaluar con radiografía o ecografía si no mejora.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 162

Futbolista de 22 años que sufre giro brusco con la rodilla semiflexionada. Presenta edema articular rápido (hemartros), signo del cajón anterior positivo y prueba de Lachman positiva. **¿Qué estructura se lesionó?**

A Ligamento cruzado anterior (LCA)
B Ligamento cruzado posterior (LCP)
C Ligamento colateral medial (LCM)
D Menisco medial
E Ligamento patelofemoral

Respuesta A. Cajón anterior (+) + Lachman (+) + hemartros post trauma en valgus/rotación = ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA). Es la lesión ligamentaria más frecuente en deportistas jóvenes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 8

Un paciente de 65 años sufre una caída a nivel, con golpe en la rodilla derecha. Evoluciona con dolor e impotencia funcional. Se observa depresión suprarrotuliana en dicha rodilla y se solicita una radiografía de rodilla derecha, que no evidencia rasgos de fractura. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Luxación de rótula
B Disfunción patelo-femoral
C Rotura del ligamento cruzado anterior
D Rotura del ligamento rotuliano
E Rotura del ligamento del cuádriceps

Respuesta E. Solo por la anatomía es posible adivinar la respuesta. El ligamento del cuádriceps está sobre la rótula. El tendón rotuliano está debajo de la rótula y se inserta en la tuberosidad tibial.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 141

Una paciente de 65 años, con IMC: 34, consulta por dolor progresivo, de una semana de evolución, en la cara lateral de la cadera, que aumenta con la caminata y limita sus movimientos. Además, en el último tiempo, el dolor le impide dormir para ese lado. Al examen físico tiene dolor a la palpación de la cara externa de la cadera y a la rotación externa forzada. **El diagnóstico más probable es:**

A Coxartrosis
B Fractura incompleta de cadera por estrés
C Hernia del núcleo pulposo, con radiculopatía L2
D Bursitis trocantérica
E Síndrome de la fascia lata rígida

Respuesta D. Dolor lateral de la cadera, que empeora al caminar y al dormir sobre ese lado, con dolor a la palpación de la cara externa, en una paciente obesa, es una bursitis trocantérica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 159

Paciente obeso con dolor en la cara externa de la cadera, claudicación y dolor a la palpación lateral con limitación a la rotación interna. **¿Diagnóstico más probable?**

A Coxartrosis (artrosis de cadera)
B Síndrome de la banda iliotibial
C Tendinopatía del glúteo medio
D Bursitis trocantérica
E Fractura de estrés del cuello femoral

Respuesta D. Un paciente obeso con dolor en la cara externa de la cadera y dolor a la palpación lateral tiene una bursitis trocantérica.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente relata que al caminar siente que su rodilla se queda atascada y le duele. Al examen con la maniobra de Apley, le duele al rotar en rotación externa. **¿Cuál es el diagnóstico y el examen de elección?**

A Lesión del menisco externo; radiografía de rodilla
B Lesión del menisco interno; resonancia magnética nuclear
C Rotura del ligamento cruzado anterior; resonancia magnética
D Lesión del menisco interno; radiografía de rodilla en dos proyecciones
E Disfunción patelofemoral; solo reposo y AINEs

Respuesta B. Con la maniobra de Apley, si duele a la rotación externa está lesionado el menisco interno. El bloqueo articular es característico de lesión meniscal, y el diagnóstico se confirma con resonancia magnética, porque la radiografía no ve los meniscos.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un deportista de cuarenta años va corriendo y siente súbitamente como una pedrada intensa en el talón. No puede caminar. La maniobra de Thompson está alterada. **¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?**

A Esguince de tobillo grado tres; inmovilización con bota removible

B Rotura del tendón de Aquiles; cirugía urgente

C Rotura del tendón de Aquiles; inmovilización con yeso

D Fractura de calcáneo; radiografía de pie

E Desgarro muscular de gemelos; RICE y AINEs

Respuesta B. El dolor súbito en el talón, como una pedrada, al correr, más la maniobra de Thompson alterada, es el cuadro clásico de rotura del tendón de Aquiles. El libro indica cirugía. El esguince de tobillo afecta los ligamentos laterales y no altera la maniobra de Thompson.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 35 años sufrió una patada en el muslo hace cuatro días jugando fútbol. Consulta por aumento de volumen fluctuante, muy doloroso, con la piel enrojecida y caliente, y fiebre de 38,5 °C. La radiografía de fémur no muestra fractura y la ecografía muestra una colección líquida organizada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Frío local y antiinflamatorios, con control en una semana

B Drenaje quirúrgico del hematoma

C Calor local y reposo absoluto

D Inmovilización con yeso por tres semanas

E Solo analgesia y alta, porque es una contusión

Respuesta B. Un hematoma se maneja de forma conservadora, pero está indicado el drenaje quirúrgico cuando es muy grande, muy doloroso o con signos de infección secundaria (calor, rubor, fiebre). Aquí hay una colección organizada con signos de infección.

▶ VER CLASE 4.02.2.012 Luxación del hombro

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.4 · Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial

QUÉ HAY QUE SABER

- Luxación anterior (la más frecuente): trauma con brazo en abducción y rotación externa; hombro en charretera, brazo en abducción y rotación externa, impotencia funcional.
- Radiografía AP y axial o lateral antes de reducir para descartar fractura asociada (troquíter, cuello humeral).
- Evaluar y registrar antes y después de la reducción el nervio axilar (sensibilidad del parche deltoideo) y los pulsos distales.
- Reducción cerrada precoz con analgesia/sedación (tracción-contratracción, Kocher u otras); radiografía de control y nuevo examen neurovascular.
- Inmovilización con cabestrillo por 2–3 semanas y luego kinesioterapia; luxación posterior sospecharla en convulsiones o electrocución.
- Seguimiento: derivar a traumatología, sobre todo en jóvenes por alto riesgo de recidiva e inestabilidad.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 35

Un paciente de 23 años sufre una caída jugando fútbol, cayendo con el hombro derecho contra el piso, con una luxación anterior de hombro derecho confirmada con radiografías, que descartan fracturas. **¿Qué evaluación debe realizarse obligatoriamente en el examen físico antes de proceder con las maniobras de reducción?**

A Buscar presencia de equimosis

B Buscar deformación en "charretera"

C Explorar la sensibilidad de la zona deltoidea

D Evaluar la impotencia funcional

E Evaluar crépito óseo

Respuesta C. La luxación anterior se asocia a lesión del nervio axilar, que da la sensibilidad de la zona deltoidea. Se debe registrar su estado antes de reducir, para que no se atribuya después a la maniobra. Las demás opciones ya se evaluaron con la clínica y la radiografía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 35

Paciente de 23 años sufre una caída mientras jugaba fútbol, cayendo con el hombro derecho contra el piso, con una luxación anterior de hombro derecho confirmada por radiografías que descartan fracturas. **¿Qué evaluación debe realizarse obligatoriamente en el examen físico antes de proceder con las maniobras de reducción?**

A Buscar presencia de equimosis

B Buscar deformación en "charretera"

C Explorar la sensibilidad de la zona deltoidea

D Evaluar la impotencia funcional

E Evaluar crépito óseo

Respuesta C. El nervio axilar es el más lesionado en la luxación anterior de hombro. Antes y después de reducir se debe documentar la sensibilidad de la cara lateral del hombro (zona del parche deltoideo) y los pulsos distales. La charretera e impotencia funcional confirman la luxación, pero no cambian la conducta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 142

Un paciente de 27 años sufre una caída a nivel, con golpe del hombro, contra el piso. Evoluciona con intenso dolor e impotencia funcional, por lo que se solicitan radiografías de hombro, que. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Reducción cruenta en una semana
B Inmovilización por 10 días con yeso
C Artroscopía para reparación del labrum
D Inmovilización por 7 días con cabestrillo bloqueado
E Reducción ortopédica de inmediato

Respuesta E. La luxación anterior de hombro se reduce ortopédicamente, de inmediato. Si recurre, se trata con cirugía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 10

Un paciente de 24 años, sufre una caída a nivel, mientras jugaba básquetbol, cayendo con el hombro izquierdo, contra el suelo. Presenta impotencia funcional y al examen físico destaca dolor a la movilización del hombro izquierdo. Se solicita una radiografía AP de hombro y axial de escápula, que se muestran a continuación: El diagnóstico más probable es:

A Luxación anterior de hombro
B Fractura de escápula
C Luxación acromioclavicular
D Fractura de clavícula
E Lesión del tendón del manguito rotador

Respuesta C. En la imagen se veía la disyunción acromioclavicular o luxación acromioclavicular, con leve desplazamiento hacia superior del extremo distal de la clavícula. La sola clínica, en este caso, no permite diferenciarlo. Sin embargo, es característico de la luxación anterior de hombro el signo de la charretera y, de la disyunción, el signo de la tecla de piano.

▶ VER CLASE 4.02.2.013 Luxofractura del tobillo

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.7 · Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante torcedura de tobillo con deformidad, dolor óseo en maléolos, equimosis inmediata y extensa e imposibilidad de apoyar.
- Radiografía de tobillo AP, lateral y mortaja antes de cualquier tratamiento; buscar fractura bimaleolar, sindesmosis inestable y fractura de Maisonneuve (cabeza del peroné).
- Manejo inicial: analgesia, reducción cerrada bajo sedación si hay luxación (sobre todo con compromiso cutáneo o vascular) e inmovilización transitoria con valva de yeso abierta.
- Examen neurovascular (pulsos, llene capilar, sensibilidad) antes y después de reducir; elevación de la extremidad.
- No tratar como esguince con bota removible; evitar yeso circular por riesgo de síndrome compartimental.
- Seguimiento: derivar a traumatología para reducción y osteosíntesis.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 138

Un paciente de 21 años sufre accidente en esquí con caída y torsión del tobillo derecho, evolucionando con dolor e impotencia funcional. Se solicita radiografía de tobillo que muestra una luxofractura. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Reposo con extremidad en elevación
B Reducción cerrada e inmovilización con valva de yeso
C Analgésicos y apoyo progresivo con mínima carga
D Vendaje compresivo
E Tracción e inmovilización con yeso de la extremidad

Respuesta B. Es una luxofractura de tobillo, de manejo quirúrgico. Mientras tanto, el manejo inicial es analgesia, reducción cerrada e inmovilización transitoria con valva de yeso abierta, para evitar un síndrome compartimental. Aplica a otras fracturas desplazadas que esperan cirugía.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente con fractura de tobillo confirmada en la radiografía. **¿Cuál es el tratamiento?**

A RICE más bota removible por cuatro semanas
B Yeso de pierna por seis semanas
C Cirugía con reducción y osteosíntesis
D Observación ambulatoria y control en una semana
E Inmovilización con bota de yeso y evaluar en dos semanas

Respuesta C. Las fracturas de fémur, pierna y tobillo se tratan quirúrgicamente por regla general. La cirugía permite reducir y fijar bien, y que el paciente apoye antes. El RICE con bota es el manejo del esguince; la inmovilización solo es parte del manejo mientras llega la cirugía.

▶ VER CLASE 4.02.2.014 Politraumatizado

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.5 · Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz

QUÉ HAY QUE SABER

- Politraumatizado: lesión de al menos dos o tres sistemas; en Chile la principal causa son los accidentes de tránsito. La lesión más llamativa no siempre es la más letal.
- Evaluación primaria ABCDE en orden: A vía aérea con control cervical (Glasgow ≤8: intubación); B ventilación (descomprimir neumotórax a tensión sin esperar radiografía); C hemorragia (compresión, dos vías gruesas, ácido tranexámico antes de 3 h, suero ≤1 L y hemoderivados); D Glasgow y pupilas; E exposición y evitar hipotermia.
- Radiografías iniciales: columna cervical lateral, tórax AP y pelvis AP en todo politraumatizado; eco-FAST para hemoperitoneo.
- Nunca sonda Foley con uretrorragia (cistostomía); sonda orogástrica, no nasogástrica, si hay fractura de base de cráneo.
- Tríada letal (hipotermia, acidosis, coagulopatía): cirugía de control de daños. Evaluación secundaria (AMPLIA) solo cuando está estable.
- Seguimiento: estabilizar y derivar a centro de trauma.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 134

Un niño de 8 años sufre un atropello mientras cruzaba la calle, resultando con golpe en la espalda y las extremidades. Ingresa con marcada disnea, saturando 85% a aire ambiental. Sus signos vitales muestran taquicardia a 150 latidos por minuto y presión arterial 70/40 mmHg. Además, se observan múltiples equimosis y, en el examen pulmonar se ausculta asimetría del murmullo pulmonar, con abolición del murmullo pulmonar izquierdo. **¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada?**

A Realizar intubación orotraqueal
B Administrar oxígeno por mascarilla de recirculación
C Puncionar el espacio pleural izquierdo
D Solicitar radiografía de tórax
E Solicitar TAC de tórax

Respuesta C. Trauma, shock, desaturación y murmullo abolido en un hemitórax: neumotórax a tensión hasta demostrar lo contrario. Se descomprime de inmediato (punción o toracostomía), antes que la vía aérea con presión positiva y sin esperar imágenes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 134

Un niño de 8 años es atropellado mientras cruzaba la calle, con golpe en la espalda y las extremidades. Ingresa con marcada disnea, saturando 85% con aire ambiental, taquicardia de 150 latidos por minuto y presión arterial 70/40 mmHg. Se observan múltiples equimosis y, en el examen pulmonar, asimetría del murmullo pulmonar, con abolición del murmullo izquierdo. **¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada?**

A Realizar intubación orotraqueal
B Administrar oxígeno por mascarilla de recirculación
C Puncionar el espacio pleural izquierdo
D Solicitar radiografía de tórax
E Solicitar TAC de tórax

Respuesta C. Politraumatizado con insuficiencia respiratoria, shock y abolición del murmullo unilateral: neumotórax a tensión, diagnóstico clínico que se resuelve en la B del ABC con descompresión inmediata (punción o toracostomía), sin esperar imágenes.

▶ VER CLASE 4.02.2.015 Trauma raquimedular

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar lesión de columna en todo politraumatizado, caída de altura, zambullida en agua poco profunda o compromiso de conciencia: collar cervical, tabla espinal y movilización en bloque.
- Clínica medular: déficit motor y sensitivo bajo un nivel, arreflexia flácida (shock espinal), priapismo, respiración diafragmática en lesión cervical, retención urinaria.
- Shock neurogénico: hipotensión con bradicardia y piel tibia y seca por pérdida del tono simpático (lesión cervical o torácica alta); descartar antes hemorragia oculta.
- Manejo inicial: ABCDE con restricción de movimiento cervical (tracción mandibular, sin hiperextender), oxígeno, volumen cauteloso y vasopresor (noradrenalina), atropina si la bradicardia es sintomática; sonda vesical si no hay uretrorragia.
- Imágenes: radiografía lateral cervical no basta; TAC de columna (y RM si hay déficit neurológico).
- Seguimiento: derivar urgente a centro con neurocirugía o traumatología de columna.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 39

Una paciente de 67 años consulta por dolor de espalda, que inició de manera súbita, en relación a actividades en las que levantaba peso en flexión. El dolor es intenso, por lo que limita sus actividades de la vida diaria. Al examen físico, se observa dolor a los movimientos de flexoextensión de la columna y se observa tórax encorvado, pero sin cifosis. Su examen neurológico es normal y presenta dolor a la palpación vertebral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Lumbago mecánico
B Lumbociática mecánica
C Fractura de cuerpo vertebral
D Espondiloartrosis lumbar
E Espondilitis anquilosante

Respuesta C. Aunque al inicio parece un lumbago mecánico, la edad, el tórax encorvado y el dolor a la palpación vertebral sugieren una fractura vertebral.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 25 años se lanza de cabeza a una piscina poco profunda. Llega inmovilizado con collar cervical. Vía aérea permeable, respira con patrón diafragmático, PA 80/45 mmHg, FC 52 lpm, piel tibia y seca. No mueve las 4 extremidades, tiene anestesia bajo las clavículas y priapismo. FAST negativo y sin otras lesiones evidentes. **¿Cuál es la causa más probable de la hipotensión?**

A Shock neurogénico por lesión medular cervical
B Shock hemorrágico por lesión abdominal oculta
C Shock espinal sin repercusión hemodinámica
D Neumotórax a tensión
E Taponamiento cardíaco

Respuesta A. Hipotensión con bradicardia y piel tibia en un trauma cervical con tetraplejia es shock neurogénico: pérdida del tono simpático. Se maneja con volumen cauteloso y vasopresores, manteniendo restricción de movimiento de la columna. El shock hemorrágico da taquicardia y piel fría; el shock espinal es la arreflexia transitoria, no un estado hemodinámico.

Conocimientos generales

7 códigos

▶ VER CLASE 4.02.3.001 **Accidentes del trabajo**

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.14 · Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Ley 16.744: seguro obligatorio contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, financiado por el empleador y administrado por mutualidades o el ISL.
- Accidente del trabajo: lesión sufrida a causa o con ocasión del trabajo que produce incapacidad o muerte; incluye el accidente de trayecto directo entre la casa y el trabajo.
- Ante un accidente laboral: atender la urgencia, emitir la denuncia individual de accidente del trabajo (DIAT) y derivar al organismo administrador (mutual o ISL), que cubre atención, licencia y prestaciones económicas.
- No corresponde licencia común de FONASA o ISAPRE para un accidente laboral; la enfermedad profesional se califica por el organismo administrador o COMPIN.
- Prevención: uso de elementos de protección personal, capacitación, comités paritarios y vigilancia de riesgos (caídas de altura, maquinaria, ergonomía).
- La licencia médica es un documento legal: emitirla sin evaluación clínica real es delito.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Trabajadora de 40 años, contratada en una empresa, sufre una caída en la vía pública mientras se dirigía directamente desde su casa a su lugar de trabajo. Consulta en el servicio de urgencia de un hospital público por dolor en el tobillo; la radiografía muestra una fractura de maléolo lateral. **Según la Ley 16.744, ¿cómo se clasifica y maneja este evento?**

A Enfermedad común; licencia médica tipo 1 cubierta por FONASA o ISAPRE
B No tiene cobertura porque ocurrió fuera del lugar de trabajo
C Accidente de trayecto; se considera accidente del trabajo y debe ser cubierto por su organismo administrador (mutualidad o ISL)
D Enfermedad profesional; requiere evaluación por COMPIN
E Accidente escolar; cubierto por el seguro escolar

Respuesta C. La Ley 16.744 considera accidente del trabajo al ocurrido en el trayecto directo entre la habitación y el lugar de trabajo. Se notifica (DIAT) y la atención, el subsidio y la licencia tipo 5-6 son de cargo del organismo administrador del seguro (mutualidad o ISL), no de la previsión común.

▶ VER CLASE 4.02.3.002 **Complicaciones de la inmovilización con yeso**

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.1 · Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome compartimental: dolor desproporcionado que no cede con analgesia, parestesias, dolor al estiramiento pasivo y tensión bajo el yeso en las primeras horas → retirar el yeso de inmediato y fasciotomía si no mejora.
- Prevención: en fractura reciente usar valva o férula no circular, elevar la extremidad, mover los dedos y vigilar dolor, color, temperatura y llene capilar; el yeso circular se coloca cuando cede el edema.
- Lesiones por presión y úlceras cutáneas; compresión del nervio peroneo en la cabeza del peroné (pie caído).
- Trombosis venosa profunda por inmovilización prolongada de extremidad inferior: considerar tromboprofilaxis según riesgo.
- Rigidez articular y atrofia muscular por inmovilización prolongada; distrofia simpático refleja (dolor urente, alodinia, cambios tróficos, osteoporosis moteada semanas después).
- Contractura isquémica de Volkmann (mano en garra) como secuela de un síndrome compartimental no tratado.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 4

Un paciente de 20 años hace 12 horas sufre una fractura cerrada de pierna derecha, mientras jugaba fútbol, presentando dolor e impotencia funcional. Se administran analgésicos y su fractura es inmovilizada con una bota larga de yeso. Sin embargo, evoluciona con intenso dolor de la pierna, más edema del pie ipsilateral. **La conducta inicial más adecuada es:**

A Solicitar nuevas radiografías
B Administrar diuréticos
C Elevar la extremidad
D Solicitar TAC de pierna
E Retirar inmediatamente el yeso

Respuesta E. La sospecha clínica es de síndrome compartimental. La conducta adecuada es retirar el yeso de inmediato y pedir evaluación urgente por un traumatólogo para una fasciotomía amplia. El diagnóstico es clínico, aunque se puede medir la presión intracompartimental si hay un tonómetro disponible.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 57

Mujer de 40 años con fractura de muñeca que fue enyesada. 3 horas después refiere dolor intenso progresivo en el antebrazo que no cede con analgesia, parestesias y sensación de tensión bajo el yeso. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Síndrome compartimental agudo
B Trombosis venosa profunda
C Reacción alérgica al yeso
D Fractura secundaria
E Distrofia simpática refleja

Respuesta A. Dolor desproporcionado, parestesias y tensión bajo el yeso en una extremidad inmovilizada son un síndrome compartimental agudo. Es una emergencia: se retira el yeso de inmediato y se hace fasciotomía si no mejora.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 158

Paciente con fractura de muñeca enyesada; 5 horas después presenta dolor intenso, hipoestesia y llene capilar enlentecido. ¿Diagnóstico más probable?

A Síndrome compartimental agudo
B Trombosis venosa profunda del miembro superior
C Lesión arterial por el yeso
D Compresión del nervio radial
E Reacción alérgica al yeso

Respuesta A. Diagnóstico: Síndrome compartimental agudo (opción A). Síndrome compartimental agudo.

▶ VER CLASE 4.02.3.003

Factores de riesgo de artrosis

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.4 · Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada

QUÉ HAY QUE SABER

- No modificables: edad (el factor más importante), sexo femenino, genética y antecedente familiar.
- Modificables: obesidad (principal factor modificable de artrosis de rodilla, por carga y efecto inflamatorio), sobrecarga laboral o deportiva y debilidad muscular del cuádriceps.
- Secundarios: fracturas con rasgo intraarticular, luxaciones crónicas, lesiones meniscales o ligamentosas, malalineación (genu varo/valgo), displasia de cadera.
- Artropatías previas: artritis reumatoide, artritis séptica, gota, hemofilia (hemartrosis repetidas), condrocalcinosis.
- Prevención: bajar 5–10 % del peso, ejercicio aeróbico y fortalecimiento de cuádriceps, calzado amortiguado y tratamiento adecuado de fracturas articulares y displasia de cadera.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 62 años consulta por dolor mecánico de ambas rodillas de 2 años de evolución, rigidez matinal menor de 30 minutos y crujidos. IMC 34 kg/m2. Trabajó 30 años como empleada doméstica. Su madre tuvo artrosis de rodillas. **¿Cuál de sus factores de riesgo de artrosis de rodilla es modificable y su intervención tiene mayor impacto en los síntomas?**

A Sexo femenino

B Obesidad

C Edad mayor de 60 años

D Antecedente familiar de artrosis

E Antecedente laboral

Respuesta B. La obesidad es el principal factor de riesgo modificable de artrosis de rodilla: aumenta la carga articular y tiene efecto inflamatorio. Bajar al menos 5% a 10% del peso, junto con ejercicio de fortalecimiento de cuádriceps, reduce dolor y mejora función. Edad, sexo y genética no son modificables.

▶ VER CLASE 4.02.3.004 Factores de riesgo de osteoporosis

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.24 · Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica

QUÉ HAY QUE SABER

- No modificables: edad avanzada, sexo femenino, menopausia (especialmente precoz), raza blanca o asiática, antecedente familiar de fractura de cadera, fractura previa por fragilidad.
- Modificables: bajo peso (IMC <19), tabaquismo, alcohol, sedentarismo, baja ingesta de calcio y déficit de vitamina D.
- Fármacos: glucocorticoides (≥5 mg/día de prednisona por ≥3 meses, la causa más frecuente de osteoporosis secundaria), anticonvulsivantes, inhibidores de aromatasa, exceso de levotiroxina.
- Enfermedades: hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, hipogonadismo, celiaquía, artritis reumatoide, mieloma, ERC.
- Evaluación: FRAX (fractura mayor ≥20 % o cadera ≥3 % indica tratamiento) y densitometría (T-score ≤ −2,5); una fractura por fragilidad basta para diagnosticar osteoporosis.
- Prevención: calcio 1.000–1.200 mg/día, vitamina D 800–2.000 UI/día, ejercicio con carga, dejar el tabaco y prevención de caídas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 58 años, menopausia a los 50 años, consulta para control. Es delgada (IMC 19 kg/m2) y tiene los antecedentes que se listan abajo. **¿Cuál de los siguientes antecedentes constituye el factor de riesgo de osteoporosis y fractura más relevante?**

A Uso de anticonceptivos orales durante 10 años en la juventud

B Consumo de 2 tazas de café al día

C Hipertensión arterial tratada con hidroclorotiazida

D Uso de prednisona 10 mg al día durante los últimos 6 meses por polimialgia reumática

E Sobrepeso en la adolescencia

Respuesta D. Los glucocorticoides orales en dosis de 5 mg o más de prednisona por 3 meses o más son la causa más frecuente de osteoporosis secundaria y elevan el riesgo de fractura desde los primeros meses; obligan a densitometría y prevención. Las tiazidas incluso reducen la calciuria; el café moderado y los anticonceptivos no son factores relevantes.

▶ VER CLASE 4.02.3.005 Lumbociática radicular

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.11 · Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Lumbociática radicular: dolor lumbar irradiado bajo la rodilla por compresión radicular, habitualmente hernia del núcleo pulposo L4-L5 o L5-S1, frecuente tras levantar peso.
- Raíces: L5 dorso del pie y ortejo mayor, debilidad del extensor del hallux; S1 planta y borde lateral, aquiliano disminuido; L4 reflejo rotuliano disminuido.
- Banderas rojas: síndrome de cauda equina (anestesia en silla de montar, alteración esfinteriana) o déficit motor progresivo → derivación urgente y RM.
- Sin déficit: manejo médico 4–6 semanas con analgesia y mantenerse activo; la mayoría mejora.
- Prevención: higiene postural y técnica correcta para levantar peso, fortalecimiento de musculatura lumbar y abdominal, control de peso.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 38 años presenta lumbago de inicio tras levantar peso hace 10 días, irradiado por la cara posterolateral del muslo y la pierna hasta el dorso del pie y el ortejo mayor derechos, con parestesias en esa zona. Lasègue positivo a 40°. Debilidad leve de la dorsiflexión del ortejo mayor. Reflejos aquilianos simétricos. Sin alteración esfinteriana ni anestesia en silla de montar. **¿Qué raíz está más probablemente comprometida y cuál es la conducta inicial?**

A S1; resonancia magnética urgente

B S1; reposo absoluto en cama por 2 semanas

C L4; cirugía descompresiva electiva

D L5; resonancia magnética urgente y cirugía

E L5; tratamiento médico con analgesia y actividad según tolerancia

Respuesta E. Dolor hasta el dorso del pie y ortejo mayor, debilidad del extensor del hallux y aquiliano normal indican radiculopatía L5 (hernia L4-L5). Sin déficit progresivo ni síndrome de cauda equina, el manejo inicial es médico por 4 a 6 semanas, con analgesia y mantenerse activo; la resonancia se reserva para banderas rojas o falla del tratamiento.

▶ VER CLASE 4.02.3.006 Prevención de displasia de cadera (diagnóstico precoz)

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.22 · Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik

QUÉ HAY QUE SABER

- Displasia del desarrollo de la cadera: problema de salud GES; el diagnóstico precoz evita artrosis precoz, cojera y cirugía.
- Examen de caderas en todos los controles: Ortolani y Barlow bajo los 3 meses; abducción limitada y signo de Galeazzi después.
- Tamizaje universal con radiografía de pelvis a los 3 meses en todos los lactantes, tengan o no factores de riesgo.
- Factores de riesgo (sexo femenino, presentación podálica, antecedente familiar) o examen alterado bajo 3 meses: ecografía y derivación precoz.
- Tratamiento precoz con arnés de Pavlik antes de los 6 meses; evitar el envolvimiento apretado con caderas en extensión y aducción.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 40

Niño de 3 meses, radiografía anteroposterior de pelvis como tamizaje para displasia de cadera. Ángulo acetabular: 26 grados a derecha y 28 grados a izquierda. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Derivar a traumatología infantil

B Indicar doble pañal

C Indicar arnés de Pavlik

D Realizar ecografía de cadera

E Mantener los controles habituales de niño sano

Respuesta E. A los 3 meses, un índice acetabular de 30 grados o menos en ambas caderas es normal. No hay displasia que tratar ni que confirmar con otro examen: se continúa con los controles habituales.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 34

Niño de 3 meses con radiografía de pelvis con ángulos acetabulares bajo 30° bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Iniciar arnés de Pavlik de inmediato

B Mantener controles habituales

C Derivar a traumatología pediátrica urgente

D Solicitar ecografía de caderas

E Iniciar tracción cutánea

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Mantener controles habituales (opción B). Mantener controles habituales.

▶ VER CLASE 4.02.3.007 Triage

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Triage: clasificación de víctimas según gravedad y probabilidad de sobrevida para priorizar la atención en incidentes con múltiples víctimas.
- Triage START: quien camina es verde (diferido).
- Si no camina: sin respiración tras abrir la vía aérea es negro; FR >30/min es rojo.
- Luego perfusión: llene capilar >2 s o sin pulso radial es rojo; luego estado mental: no obedece órdenes simples es rojo.
- Si no camina pero pasa todos los criterios (FR ≤30, perfusión adecuada, obedece órdenes): amarillo (urgente, no inmediato).
- Durante el triage solo se hacen maniobras salvadoras breves (abrir vía aérea, comprimir hemorragias) y se reevalúa periódicamente.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Se produce un choque de un bus con múltiples víctimas. Usted llega primero al lugar y aplica triage START. Un hombre adulto no puede caminar, respira espontáneamente con una frecuencia de 24 por minuto, tiene llene capilar menor de 2 segundos y obedece órdenes simples. **¿Qué categoría de triage le corresponde?**

A Verde (leve, puede esperar)

B Amarilla (diferible)

C Roja (inmediata)

D Negra (fallecido o no recuperable)

E Roja, porque no puede caminar

Respuesta B. En START, quien camina es verde. Si no camina, se evalúa: sin respiración tras abrir la vía aérea es negra; frecuencia respiratoria mayor de 30, llene capilar mayor de 2 segundos (o sin pulso radial) o no obedece órdenes es roja. Este paciente no camina pero pasa todos los criterios: amarilla.

Exámenes e imagenología

9 códigos

▶ VER CLASE 4.02.4.001 **Radiografía de columna vertebral** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.15 · Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- El lumbago agudo mecánico sin banderas rojas no requiere imágenes: la radiografía no cambia el manejo, irradia y muestra hallazgos degenerativos irrelevantes.
- Indicaciones: trauma significativo, adulto mayor con sospecha de fractura osteoporótica (aplastamiento vertebral), sospecha de cáncer o infección, o dolor persistente >4–6 semanas pese a tratamiento.
- Hallazgos a reconocer en el informe: aplastamiento vertebral, listesis, escoliosis (ángulo de Cobb), lesiones líticas o blásticas, pinzamiento discal y osteofitos.
- Radiografía lateral cervical normal no descarta lesión en trauma: con sospecha se completa con TAC.
- Infección (espondilodiscitis), compresión medular o radiculopatía con déficit: la RM es el examen de elección, la radiografía se altera tarde.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 35 años consulta por lumbago de 5 días tras levantar una caja. Sin irradiación, sin fiebre, sin baja de peso, sin antecedente de cáncer ni de trauma mayor, sin déficit neurológico. Pide que le tomen una radiografía de columna lumbar. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a las imágenes?**

A No solicitar imágenes; reevaluar si persiste más de 4 a 6 semanas o aparecen banderas rojas

B Resonancia magnética lumbar

C Radiografía lumbar AP y lateral para descartar fractura

D TAC de columna lumbar

E Radiografía lumbar con proyecciones oblicuas

Respuesta A. El lumbago agudo inespecífico sin banderas rojas no requiere imágenes: la radiografía no cambia el manejo, irradia y detecta hallazgos degenerativos irrelevantes. Se indica radiografía ante trauma significativo, edad avanzada con sospecha de fractura osteoporótica, sospecha de cáncer o infección, o dolor persistente pese a tratamiento.

▶ VER CLASE 4.02.4.002 **Radiografía de pelvis-caderas ante sospecha de fractura** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.10 · Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: adulto mayor con caída, dolor inguinal e imposibilidad de apoyar, o politraumatizado (pelvis AP en la evaluación primaria).
- Solicitar pelvis AP (compara ambas caderas y busca fractura contralateral) más cadera AP y axial; no radiografía de fémur ni resonancia como primer examen.
- Reconocer: fractura de cuello femoral (intracapsular, riesgo de necrosis avascular si está desplazada), intertrocantérica (extracapsular), y luxación de la cabeza femoral.
- Pelvis: diástasis de la sínfisis (libro abierto), fracturas de ramas y del anillo pelviano; si hay shock no retrasar la estabilización por imágenes.
- Si la radiografía es normal y la sospecha persiste, TAC o RM para fractura oculta.
- La interpretación define la cirugía: prótesis en cuello desplazado en mayor de 65 años, osteosíntesis en los demás.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un adulto mayor de 70 años con osteoporosis sufre una caída y no puede caminar. Al examen presenta abducción, rotación externa y acortamiento de la extremidad derecha. **¿Cuál es el diagnóstico y el estudio inicial?**

A Luxación posterior de cadera; TAC de cadera

B Fractura de cadera; radiografía anteroposterior de cadera y pelvis

C Fractura de cadera; resonancia magnética de cadera

D Fractura de fémur; radiografía de fémur en dos proyecciones

E Coxartrosis aguda; radiografía de pelvis

Respuesta B. La posición impúdica con rotación externa y acortamiento, tras una caída en un adulto mayor osteoporótico, es una fractura de cadera. Se diagnostica con radiografía de cadera anteroposterior y axial más pelvis anteroposterior. La resonancia es para partes blandas, y la luxación posterior tiene posición púdica.

▶ VER CLASE 4.02.4.003 Radiografía huesos largos ante sospecha de fractura

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Traumatología 12.1 · Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización
Traumatología 12.7 · Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince

QUÉ HAY QUE SABER

- Solicitar al menos dos proyecciones perpendiculares (AP y lateral) que incluyan las articulaciones proximal y distal al foco.
- Describir: hueso y segmento (epífisis, metáfisis, diáfisis), trazo (transverso, oblicuo, espiroideo, conminuto, segmentario), desplazamiento, angulación, acortamiento y compromiso articular.
- Reglas de Ottawa en tobillo: radiografía si hay dolor óseo en maléolos o base del 5° metatarsiano, o no puede dar 4 pasos.
- En niños: reconocer fracturas en tallo verde, rodete (torus) y disyunciones epifisarias (Salter-Harris); comparar con el lado sano si hay duda.
- Fractura patológica: lesión lítica o blástica previa en el foco, trauma mínimo; signos de agresividad obligan a derivar.
- Rasgo intraarticular o luxación asociada: TAC para planificar cirugía.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 7

Una paciente de 68 años hace dos días sufre torsión del tobillo derecho, mientras bajaba escaleras. Evoluciona con intenso dolor, que le dificulta caminar. Al examen físico presenta edema de tobillo derecho, con equimosis bimaleolar, asociado a dolor a la palpación fibular ipsilateral. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar inmovilizador de tobillo

B Inmovilizar con bota larga de yeso

C Solicitar radiografías de tobillo

D Solicitar TAC de tobillo

E Indicar reposo y analgesia, con elevación de la extremidad

Respuesta C. La sospecha es una fractura de tobillo, principalmente por el dolor a la palpación ósea. Sin embargo, tanto en un esguince como en una sospecha de fractura, la conducta inicial es descartar la fractura con radiografías de tobillo (AP, lateral y oblicua).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 30 años llega a urgencias tras un accidente de tránsito con dolor e impotencia funcional en el antebrazo derecho, con deformidad visible y crepitación al examen. **¿Cuál es el diagnóstico y el estudio inicial?**

A Contusión de antebrazo; ecografía de partes blandas

B Fractura de antebrazo; radiografías anteroposterior y lateral

C Luxación de codo; TAC de antebrazo

D Fractura de antebrazo; solo radiografía anteroposterior

E Contusión grave; solo analgesia y observación

Respuesta B. Dolor, deformidad, impotencia funcional y crepitación son la clínica clásica de fractura. Se confirma con radiografías en dos proyecciones, anteroposterior y lateral. Una sola proyección no basta.

▶ VER CLASE 4.02.4.004 Radiografía de displasia cadera

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Traumatología 12.14 · Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- En Chile se tamiza con radiografía de pelvis AP a los 3 meses a todos los lactantes; bajo los 3 meses se usa ecografía.
- Trazar la línea de Hilgenreiner (horizontal por los cartílagos trirradiados) y la de Perkins (vertical desde el borde lateral del acetábulo): el núcleo o metáfisis debe quedar en el cuadrante ínfero-interno.
- Índice acetabular normal ≤30°; >30° sugiere displasia (>36° la confirma según el libro).
- Otros signos: núcleo o metáfisis desplazados hacia arriba y afuera, ruptura del arco de Shenton, retraso de osificación del núcleo respecto al lado sano.
- La ausencia del núcleo de osificación a los 3 meses puede ser normal y no indica por sí sola luxación.

- Radiografía alterada: derivar a ortopedia infantil para tratamiento con arnés de Pavlik.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 3 meses, sexo femenino, primera hija, nacida en presentación podálica, asiste a control de salud. El examen de caderas muestra leve limitación de la abducción izquierda, sin signos de Ortolani ni Barlow. Según la normativa ministerial, corresponde el tamizaje por imagen a esta edad. **¿Qué hallazgo de la radiografía de pelvis apoya el diagnóstico de displasia de cadera?**

A Índice acetabular aumentado, sobre 30 grados, con la metáfisis femoral desplazada hacia afuera de la línea de Perkins y ruptura del arco de Shenton

B Índice acetabular de 20 grados con el núcleo femoral en el cuadrante inferior interno

C Ausencia de núcleo de osificación de la cabeza femoral, que siempre indica luxación

D Línea de Hilgenreiner que pasa por ambos cartílagos trirradiados

E Densidad ósea disminuida en ambas caderas

Respuesta A. En Chile se tamiza con radiografía de pelvis a los 3 meses. Sugieren displasia un índice acetabular mayor de 30 grados, la metáfisis o el núcleo femoral fuera del cuadrante inferointerno formado por las líneas de Hilgenreiner y Perkins, y la ruptura del arco de Shenton. La ausencia del núcleo de osificación puede ser normal a esta edad.

▶ VER CLASE 4.02.4.005 Radiografía en tumores oseos

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.13 · Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing

QUÉ HAY QUE SABER

- Evaluar tres datos: edad del paciente, ubicación en el hueso (epífisis, metáfisis, diáfisis) y aspecto radiológico.
- Benignidad: bordes bien delimitados con halo esclerótico, cortical respetada o adelgazada, sin invasión de partes blandas ni reacción perióstica compleja.
- Malignidad: bordes mal definidos, cortical rota, masa de partes blandas, reacción perióstica en sol naciente, triángulo de Codman o telas de cebolla.
- Patrones: osteocondroma (exostosis desde la metáfisis); osteoma osteoide (nidus radiolúcido <1 cm con esclerosis); osteosarcoma (metáfisis del adolescente, sol naciente); Ewing (diáfisis del niño, telas de cebolla); células gigantes (epífisis del adulto, lítico en pompas de jabón).
- Metástasis: lesiones líticas o blásticas múltiples en adulto; mieloma con lesiones en sacabocado.
- Aspecto agresivo: derivar a centro especializado para RM de todo el hueso, TAC de tórax y biopsia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Adolescente de 15 años consulta por dolor en la rodilla izquierda de 2 meses, que lo despierta en la noche, y aumento de volumen. La radiografía muestra en la metáfisis distal del fémur una lesión de bordes mal definidos, con destrucción cortical, formación de hueso en rayos de sol y un triángulo de Codman. **¿Cuál es la interpretación radiológica y el diagnóstico más probable?**

A Lesión benigna de márgenes escleróticos; osteocondroma

B Nidus radiolúcido menor de 1 cm con esclerosis; osteoma osteoide

C Lesión lítica central bien delimitada; quiste óseo simple

D Lesión agresiva con reacción perióstica maligna; osteosarcoma

E Lesión epifisaria en pompas de jabón; tumor de células gigantes

Respuesta D. Bordes mal definidos, rotura cortical, reacción perióstica en rayos de sol y triángulo de Codman son signos radiológicos de agresividad. En la metáfisis de un adolescente, el diagnóstico más probable es osteosarcoma; se deriva para resonancia de todo el hueso, TC de tórax y biopsia en centro especializado.

▶ VER CLASE 4.02.4.006 Set radiológico de trauma en conjunto (columna cervical, tórax, pelvis y columna)

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.5 · Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz

QUÉ HAY QUE SABER

- Todo politraumatizado lleva radiografía de columna cervical lateral, tórax AP y pelvis AP, aunque esté estable o asintomático.
- Cervical lateral: debe verse de C1 hasta C7-T1; evaluar alineación de las cuatro líneas, cuerpos vertebrales y partes blandas prevertebrales. Normal no descarta lesión: con sospecha completar con TAC y mantener el collar.
- Tórax AP: neumotórax, hemotórax, contusión pulmonar, fracturas costales, ensanchamiento mediastínico (lesión aórtica), posición del tubo endotraqueal.
- Pelvis AP: fracturas del anillo pelviano y diástasis de sínfisis (libro abierto), que explican shock hipovolémico.
- Columna toracolumbar: según mecanismo y examen, idealmente con TAC.
- Si el paciente está inestable, las imágenes no deben retrasar la reanimación (neumotórax a tensión se descomprime clínicamente).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente politraumatizado llega a urgencias tras un accidente de tránsito. **¿Cuáles son las tres radiografías mínimas que se deben solicitar?**

A Anteroposterior de tórax, anteroposterior de abdomen y lateral de rodilla

B Lateral de cuello, anteroposterior de tórax y anteroposterior de pelvis

C Anteroposterior de tórax, TAC de cerebro y anteroposterior de pelvis

D Solo anteroposterior de tórax si el paciente está estable

E Radiografías de todos los huesos largos más AP de tórax

Respuesta B. Las tres radiografías mínimas son lateral de cuello, para fractura cervical, AP de tórax, para neumotórax o hemotórax, y AP de pelvis, para fractura de pelvis. Se piden siempre, aunque el paciente esté estable.

▶ VER CLASE 4.02.4.007 Citoquimico de líquido articular

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.12 · Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: toda monoartritis aguda o derrame articular no filiado, antes del antibiótico.
- No inflamatorio (tipo I): 200–2.000 leucocitos, PMN <25 %, glucosa igual a la sangre: artrosis o causa mecánica.
- Inflamatorio (tipo II): 2.000–50.000 leucocitos: cristales (gota con agujas de birrefringencia negativa; pseudogota con romboidales débilmente positivos) o artritis reumatoide.
- Séptico (tipo III): >50.000 leucocitos, PMN >90 %, glucosa <50 % de la glicemia, turbio: hospitalizar, antibióticos EV y drenaje.
- Hemorrágico: trauma con lesión ligamentosa, fractura (gotas de grasa) o coagulopatía (hemofilia).
- Trampa: los cristales no descartan infección (pueden coexistir) y una crisis gotosa puede superar 50.000 leucocitos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 60 años, diabético, consulta por dolor, calor y aumento de volumen de la rodilla izquierda de 2 días, con fiebre de 38,6 grados. Se realiza artrocentesis, que obtiene líquido turbio. Citoquímico: 85.000 leucocitos por mm3 con 92% de polimorfonucleares, glucosa 20 mg/dL (glicemia 160 mg/dL). No se observan cristales. Gram pendiente. **¿Cuál es la interpretación y la conducta más adecuada?**

A Líquido no inflamatorio por artrosis; paracetamol y kinesioterapia

B Líquido séptico; hospitalizar, tomar hemocultivos, iniciar antibióticos endovenosos empíricos y drenaje articular

C Gota aguda; colchicina y alta

D Líquido hemorrágico; reposo y frío local

E Líquido inflamatorio leve; infiltrar corticoides intraarticulares

Respuesta B. Un líquido articular turbio con más de 50.000 leucocitos por mm3, predominio polimorfonuclear sobre 90% y glucosa muy baja respecto de la sangre es séptico hasta demostrar lo contrario. Se hospitaliza, se cultiva, se inician antibióticos empíricos con cobertura de Staphylococcus aureus y se drena. Los corticoides intraarticulares están contraindicados.

▶ VER CLASE 4.02.4.008 Cultivo y antibiograma en infecciones osteoarticulares y heridas

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.2 · Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos

QUÉ HAY QUE SABER

- En sospecha de artritis séptica u osteomielitis, tomar hemocultivos (×2) y cultivo del líquido articular o de tejido óseo antes del primer antibiótico, porque este negativiza los cultivos.
- El cultivo demora 48–72 h: no se espera para iniciar antibiótico empírico; el antibiograma permite ajustar (S. aureus sensible a cefazolina/cloxacilina; SAMR a vancomicina).
- En osteomielitis la muestra válida es ósea (biopsia o quirúrgica); el hisopado superficial de piel o fístula no representa al germen profundo.
- Heridas: cultivar solo heridas con signos de infección, tras limpiar, de tejido profundo o pus; no se cultivan heridas limpias.
- Interpretar: S. aureus es el agente más frecuente; gonococo crece mal (pedir cultivo en medio especial y de mucosas); Gram negativo no descarta infección.
- Ajustar el esquema y la duración según germen y sensibilidad informados.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 55 años, diabético, consulta por rodilla derecha caliente, roja y con derrame de 2 días, fiebre de 38,8 °C. Está hemodinámicamente estable. Se planifica tratamiento antibiótico endovenoso. **¿Qué se debe hacer antes de iniciar los antibióticos?**

A Nada; el inicio de antibióticos no debe retrasarse por ningún examen

B Tomar cultivo de un hisopado de la piel sobre la rodilla

C Solicitar resonancia magnética de rodilla

D Tomar hemocultivos y artrocentesis con Gram y cultivo del líquido articular

E Esperar resultado de la VHS y PCR

Respuesta D. En la sospecha de artritis séptica en un paciente estable, se toman hemocultivos y se punciona la articulación (Gram, cultivo, recuento celular y cristales) antes del primer antibiótico, porque este negativiza los cultivos. El antibiograma permite ajustar el esquema empírico. El hisopado de piel no representa al germen articular.

▶ VER CLASE 4.02.4.009 **Gram líquido articular** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.1 · Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial

QUÉ HAY QUE SABER

- Tinción rápida del líquido sinovial que orienta el antibiótico empírico mientras llega el cultivo.
- Cocos grampositivos en racimo: S. aureus (el más frecuente); en cadena: estreptococos; diplococos gramnegativos intracelulares: gonococo; bacilos gramnegativos en ancianos, ITU o usuarios de drogas EV.
- Es específico pero poco sensible (~50 %; menos del 25 % en gonococo): un Gram negativo no descarta artritis séptica.
- Con líquido >50.000 leucocitos y fiebre se trata como séptica aunque el Gram sea negativo o haya cristales, hasta el resultado del cultivo.
- Se interpreta junto con el citoquímico y la búsqueda de cristales con luz polarizada.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 70 años con monoartritis aguda de rodilla izquierda y fiebre. La artrocentesis obtiene líquido turbio con 65.000 leucocitos/mm3, 92% polimorfonucleares. Se observan cristales romboidales con birrefringencia positiva débil. El Gram es negativo (no se observan bacterias). **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Pseudogota; el Gram negativo descarta infección

B Artritis séptica descartada; iniciar colchicina

C No se puede descartar artritis séptica: el Gram tiene baja sensibilidad; iniciar antibióticos empíricos hasta el resultado del cultivo

D Gota aguda; indicar AINE

E Artritis reactiva; buscar infección genitourinaria

Respuesta C. El Gram del líquido sinovial es específico pero poco sensible (cerca de 50%): un Gram negativo no descarta artritis séptica. Además, cristales e infección pueden coexistir. Con líquido de más de 50.000 leucocitos y fiebre, se trata empíricamente como séptica hasta que el cultivo resulte negativo.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 5 códigos

▶ VER CLASE 4.02.5.001 **Inmovilizaciones de urgencia** NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.1 · Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización
Traumatología 12.2 · Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente

QUÉ HAY QUE SABER

- Objetivo: disminuir dolor, sangrado y daño de partes blandas y neurovascular, y permitir un traslado seguro.
- Antes: ABC; examinar y registrar pulsos, llene capilar, sensibilidad y motilidad distal; retirar anillos y joyas.
- Técnica: alinear con tracción suave en el eje, inmovilizar incluyendo la articulación proximal y distal al foco con férulas o valvas acolchadas no circulares; extremidad elevada.
- Ejemplos: valva antebraquiopalmar en muñeca; cabestrillo en clavícula y hombro; férula larga desde muslo a pie en pierna; collar cervical y tabla espinal en sospecha de columna.
- Fractura expuesta: no suturar, cubrir con apósito estéril, valva larga y abierta.
- Contraindicado el yeso circular cerrado y vendajes compresivos en agudo (síndrome compartimental); reevaluar el estado neurovascular después de inmovilizar.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 34 años se cae de una bicicleta y llega al SAPU con dolor y deformidad en el tercio medio de la pierna izquierda. La piel está indemne, pulsos pedios presentes, llene capilar menor de 2 segundos y sensibilidad conservada. Debe ser trasladada al hospital, a 40 minutos. **¿Cuál es la inmovilización de urgencia más adecuada antes del traslado?**

A Yeso circular cerrado desde el muslo hasta el pie

B Vendaje elástico compresivo solo sobre el foco de fractura

C Férula que incluya la articulación proximal y distal (rodilla y tobillo), previa alineación suave y con control neurovascular antes y después

D No inmovilizar para no retrasar el traslado

E Reducción forzada bajo anestesia local y luego traslado sin férula

Respuesta C. La inmovilización de urgencia debe incluir la articulación por encima y por debajo de la fractura, alinear con tracción suave, usar férulas acolchadas no circulares y registrar el estado neurovascular antes y después. El yeso circular en agudo está contraindicado por el edema y el riesgo de síndrome compartimental.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 26 años cae de una escalera sobre la mano extendida. Llega al SAPU con dolor y deformidad en dorso de tenedor en la muñeca derecha. Piel indemne, llene capilar normal y sensibilidad conservada en los dedos. Se decide inmovilizar antes de derivarlo para radiografía y manejo definitivo. **¿Cuál es la inmovilización de urgencia más adecuada?**

A Yeso circular braquiopalmar cerrado

B Vendaje elástico compresivo apretado desde la mano al codo

C Solo cabestrillo, sin férula

D Valva o férula antebraquiopalmar acolchada, sin cerrar en forma circular, con cabestrillo y control neurovascular

E Reducción forzada sin analgesia y luego vendaje

Respuesta D. En urgencia se inmoviliza con férulas o valvas acolchadas no circulares que incluyan las articulaciones vecinas, dejando espacio para el edema, con elevación y registro neurovascular antes y después. El yeso circular cerrado y los vendajes compresivos en agudo arriesgan un síndrome compartimental.

▶ VER CLASE 4.02.5.002 Punción articular de rodilla

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.12 · Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: diagnóstica en toda monoartritis o derrame no filiado (descartar artritis séptica, cristales), y evacuadora en derrame a tensión o hemartrosis. Siempre antes del antibiótico.
- Única contraindicación absoluta habitual: celulitis o infección de la piel en el sitio de punción (elegir otro abordaje). La anticoagulación en rango y la aspirina no la contraindican.
- Técnica: paciente en decúbito supino con rodilla extendida y cuádriceps relajado, asepsia rigurosa, abordaje suprapatelar lateral bajo el borde superolateral de la rótula, con aguja gruesa.
- Enviar líquido a citoquímico con recuento y diferencial, glucosa, Gram, cultivo y cristales con luz polarizada.
- No se infiltran corticoides si se sospecha artritis séptica; en hemofílicos no puncionar sin reponer factor.
- Complicaciones: infección iatrogénica, hemartrosis, dolor.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años con derrame a tensión de rodilla derecha de 24 horas, sin trauma. Se decide artrocentesis diagnóstica en el servicio de urgencia. **¿Cuál de las siguientes condiciones contraindica realizar la punción por la vía planificada?**

A Fiebre de 38,5 °C

B Celulitis de la piel en el sitio de punción

C Uso de aspirina en dosis baja

D Antecedente de gota

E Derrame mayor de 50 mL

Respuesta B. La única contraindicación absoluta habitual de la artrocentesis es la infección de piel o celulitis sobre el sitio de punción, porque se puede inocular la articulación; se elige otro abordaje. La fiebre es una indicación (descartar artritis séptica). La antiagregación o anticoagulación en rango no la contraindica. Se usa técnica aséptica, habitualmente por abordaje suprapatelar lateral.

▶ VER CLASE 4.02.5.003 Reducción de luxaciones de codo, hombro e interfalángicas

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.4 · Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial

QUÉ HAY QUE SABER

- Procedimiento que se deriva a especialista; el médico general sospecha, inmoviliza, analgesia y deriva.
- Antes de reducir: radiografía para descartar fractura asociada y examen neurovascular documentado (hombro: nervio axilar y pulsos; codo: arteria braquial, mediano y cubital).

- Hombro anterior: tracción-contratracción u otras maniobras bajo analgesia/sedación. Codo posterior: tracción longitudinal del antebrazo con contratracción y flexión progresiva. Interfalángica: tracción axial y presión sobre la falange luxada.
- Después de reducir: repetir el examen neurovascular y la radiografía de control.
- Inmovilización breve (cabestrillo en hombro, codo en flexión, sindactilia en dedos) y movilización precoz para evitar rigidez.
- Luxación posterior de cadera: reducción cerrada urgente bajo anestesia en pabellón por especialista.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años con luxación posterior de codo izquierdo tras caída, sin fracturas en la radiografía. Antes de reducir, el pulso radial está presente y la sensibilidad de la mano es normal. Se reduce mediante tracción longitudinal del antebrazo con contratracción del brazo y flexión progresiva. **Inmediatamente después de la reducción, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Dar de alta con analgesia, sin inmovilización

B Solicitar resonancia magnética urgente

C Inmovilizar con yeso en extensión por 6 semanas

D Reevaluar pulsos y función neurológica, controlar con radiografía y dejar férula braquiopalmar por un período corto

E Iniciar ejercicios de fuerza inmediatamente

Respuesta D. Tras toda reducción de una luxación se debe reexaminar el estado neurovascular (la arteria braquial y los nervios mediano y cubital pueden quedar atrapados), confirmar la reducción con radiografía e inmovilizar brevemente en flexión, con movilización precoz para evitar rigidez. Inmovilizar en extensión o por largo tiempo produce rigidez.

▶ VER CLASE 4.02.5.004 Tracción de partes blandas

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.10 · Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía

QUÉ HAY QUE SABER

- Tracción de partes blandas (cutánea): vendas adheridas a la piel con pesos bajos (hasta 3–5 kg en adultos), usada transitoriamente para alinear, disminuir el dolor y el espasmo (p. ej., fractura de cadera o fémur mientras espera cirugía).
- Técnica: piel sana e indemne, almohadillar prominencias óseas, vendaje desde el tobillo hasta bajo la rodilla o muslo, peso colgando libre en el eje.
- Complicaciones a vigilar: lesiones cutáneas por fricción o presión (flictenas, úlceras) y neuropraxia del peroneo común en la cabeza del peroné.
- Controlar periódicamente piel, sensibilidad y dorsiflexión del pie y llene capilar.
- Contraindicada sobre piel lesionada o con heridas; para pesos mayores se usa tracción esquelética (riesgo de infección del trayecto de los clavos).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 82 años con fractura pertrocantérea de cadera derecha espera cirugía, programada en 48 horas. Se instala tracción de partes blandas (cutánea) en la extremidad, con vendaje y peso de 3 kg. **¿Cuál es la complicación que más se debe vigilar por esta tracción?**

A Trombosis arterial femoral

B Osteomielitis del trayecto de los clavos

C Síndrome de embolia grasa causado por la tracción

D Luxación de la rodilla

E Lesión de la piel (flictenas, úlceras por presión) y compresión del nervio peroneo a nivel de la cabeza del peroné

Respuesta E. La tracción de partes blandas usa vendas adheridas a la piel con pesos bajos (hasta 3 a 5 kg en adultos). Sus complicaciones típicas son lesiones cutáneas por fricción o presión y neuropraxia del peroneo común en la cabeza del peroné; se vigilan piel, sensibilidad y dorsiflexión. La infección del trayecto es propia de la tracción esquelética.

▶ VER CLASE 4.02.5.005 Traslado del traumatizado

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.2 · Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente

QUÉ HAY QUE SABER

- Antes del traslado: ABCDE y estabilización (vía aérea, control de hemorragia, dos vías venosas, volumen); coordinar con el centro receptor.
- Sospecha de lesión de columna: collar cervical rígido y tabla espinal, movilización en bloque; nunca permitir que camine ni trasladar sentado.
- Retirar el casco solo con técnica entre dos operadores manteniendo la alineación cervical; nunca tirando bruscamente.
- Inmovilizar fracturas con férulas que incluyan articulaciones vecinas; fractura expuesta con apósito estéril y valva abierta; pelvis inestable con sábana pélvica.
- Evitar hipotermia (cubrir, fluidos tibios), registrar Glasgow, signos vitales y estado neurovascular, y reevaluar durante el traslado.
- No retrasar el traslado esperando radiografías cuando el paciente requiere un centro de mayor complejidad.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un motociclista de 30 años choca a alta velocidad en una carretera rural. Al llegar el equipo de rescate, está confuso con Glasgow 13, se queja de dolor cervical y tiene deformidad del muslo derecho. Respira espontáneamente, presión arterial 110/70 mmHg y frecuencia cardíaca 105 por minuto. Aún tiene el casco puesto. **¿Cuál es la conducta más adecuada para su traslado?**

A Sentarlo en el auto de un testigo para llegar más rápido al hospital

B Mantener la vía aérea, retirar el casco entre dos personas con estabilización manual de la columna, colocar collar cervical, tabla espinal y férula de la extremidad, y trasladar monitorizado al centro adecuado

C Retirar el casco tirando de él rápidamente para evaluar la cara

D Esperar en el lugar a tener radiografías antes de movilizarlo

E Trasladarlo en decúbito lateral sin inmovilización cervical para evitar aspiración

Respuesta B. Todo politraumatizado con mecanismo de alta energía, compromiso de conciencia o dolor cervical se traslada con restricción de movimiento espinal: vía aérea primero, retiro del casco entre dos operadores con estabilización manual, collar, tabla, férulas en las fracturas, oxígeno y monitorización, hacia el centro con capacidad resolutiva.

14 UROLOGÍA

62 CÓDIGOS

134 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	28
Situaciones clínicas de urgencia	9
Conocimientos generales	6
Exámenes e imagenología	13
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	6

Situaciones clínicas

28 códigos

▶ VER CLASE **4.03.1.001** **Balanitis, balano postitis**

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.16 · Patología Peneana: Fimosis, Parafimosis, Balanopostitis, Priapismo & Disfunción Eréctil

QUÉ HAY QUE SABER

- Balanopostitis: inflamación de glande y prepucio con eritema, edema, prurito, secreción y mal olor; favorecida por fimosis, mala higiene, diabetes y obesidad.
- Etiología: Candida (la más frecuente, sobre todo en diabéticos: placas blanquecinas), bacteriana (estreptococo, anaerobios), irritativa o por ITS; en recurrentes pedir glicemia/HbA1c.
- Tratamiento: aseo con agua tibia y secado, retracción suave; candidiásica: clotrimazol 1% crema 2 veces al día por 7–14 días (o fluconazol 150 mg oral dosis única); bacteriana: antibiótico tópico u oral según clínica.
- Tratar a la pareja si es candidiásica recurrente o hay sospecha de ITS; descartar sífilis, herpes y VIH ante úlceras.
- Seguimiento: control de la respuesta y del factor predisponente; balanitis recurrente con fimosis es indicación de circuncisión.
- Lesión persistente, indurada o que no responde en 4–6 semanas: derivar para biopsia (liquen escleroso, eritroplasia de Queyrat, carcinoma).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años, obeso, no circuncidado, consulta por ardor y prurito del glande de 2 semanas. Al examen se observa eritema del glande y del prepucio con pápulas satélites y un exudado blanquecino. No tiene secreción uretral. Nunca se ha controlado la glicemia. **Además del tratamiento tópico, ¿qué examen es más importante solicitar?**

A Glicemia en ayunas

B VDRL

C Cultivo de secreción uretral para gonococo

D Biopsia del glande

E Ecografía testicular

Respuesta A. Eritema del glande con pápulas satélites y exudado blanquecino sugiere balanopostitis candidiásica, que se trata con antifúngico tópico (clotrimazol) e higiene. Es frecuente en diabéticos y puede ser su primera manifestación, por lo que debe solicitarse glicemia. La biopsia se reserva para lesiones persistentes pese a tratamiento.

▶ VER CLASE **4.03.1.002** **Cáncer de próstata**

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.8 · Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason
Urología 13.9 · Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia)

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer de próstata: el más frecuente en el hombre chileno; nace en la zona periférica posterior, por lo que en etapa precoz es asintomático y no obstruye.
- Factores de riesgo: edad (raro antes de 45–50 años), familiar de primer grado (duplica o triplica el riesgo, BRCA2) y ascendencia africana.
- Sospecha: nódulo pétreo, asimetría o próstata fija al tacto rectal (biopsia aunque el APE sea normal) o APE >4 ng/mL confirmado a las 4–6 semanas (tratar antes una ITU o prostatitis).
- Ajustes del APE: con finasteride/dutasteride >6 meses se multiplica por 2; relación libre/total <15% en zona gris 4–10 aumenta la sospecha.
- GES (desde 15 años): biopsia dentro de 30 días desde la sospecha fundada y tratamiento dentro de 60 días desde la confirmación.
- Seguimiento: derivar a urología; dolor óseo, APE muy alto y fosfatasas elevadas sugieren metástasis blásticas (cintigrama óseo).

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 103

Paciente de 83 años con APE 10, adenocarcinoma de próstata Gleason 3+3 en 0,3% de la muestra, estudio de diseminación negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Vigilancia activa con control en 3 meses

B Prostatectomía radical

C Radioterapia de haz externo

D Braquiterapia prostática

E Deprivación androgénica

Respuesta A. Tumor de bajo riesgo, mínimo, sin diseminación, en un adulto mayor: vigilancia activa.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 61 años, asintomático. Tacto rectal normal. APE total de 6,2 ng/mL; descartada una infección urinaria, se repite a las 4 semanas: 6,4 ng/mL, con relación APE libre/total de 9%. **¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?**

A Tamsulosina y control con APE en 1 año

B Biopsia prostática guiada por ecografía transrectal

C Cintigrama óseo de entrada

D Finasteride por 6 meses para ver si el APE baja

E Tranquilizar porque no hay nódulo

Respuesta B. APE confirmado en la zona gris con fracción libre de 9%, menor de 15%: alto riesgo de cáncer. Corresponde biopsia. El finasteride enmascararía el APE y retrasaría el diagnóstico.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

La biopsia prostática informa: adenocarcinoma acinar con patrón Gleason primario 4 en 60% del tumor y patrón secundario 3 en 40%. **¿Cuál es el score de Gleason y el grupo ISUP?**

A Gleason 3+4=7; ISUP 2

B Gleason 4+3=7; ISUP 3

C Gleason 4+4=8; ISUP 4

D Gleason 3+3=6; ISUP 1

E Gleason 4+5=9; ISUP 5

Respuesta B. El primer número es el patrón más abundante (4) y el segundo el siguiente (3): 4+3=7, grupo ISUP 3, de peor pronóstico que 3+4.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En relación con las garantías explícitas en salud para el cáncer de próstata en Chile, ¿cuál es el plazo máximo para realizar la confirmación diagnóstica con biopsia desde la sospecha clínica fundada? **¿Cuál es el plazo máximo?**

A 10 días

B 30 días

C 60 días

D 90 días

E 180 días

Respuesta B. La biopsia se garantiza dentro de 30 días desde la sospecha. Una vez confirmada, el tratamiento primario comienza dentro de 60 días.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 76 años con dolor lumbar de 2 meses que empeora de noche. Sin déficit neurológico. Próstata pétrea y fija. APE 145 ng/mL y fosfatasas alcalinas 420 U/L. El cintigrama óseo muestra múltiples focos hipercaptantes en columna, pelvis y fémures. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A Prostatectomía radical con linfadenectomía

B Terapia de deprivación androgénica

C Vigilancia activa con APE cada 3 meses

D Radioterapia prostática exclusiva con intención curativa

E Resección transuretral de próstata

Respuesta B. Cáncer de próstata metastásico óseo: el pilar es la deprivación androgénica, médica o quirúrgica. Si se usa un agonista de GnRH como leuprolide, se agrega bicalutamida inicial para evitar el flare.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años, activo, con expectativa de vida sobre 20 años. Adenocarcinoma ISUP 2 (Gleason 3+4=7) en 4 de 12 cilindros, APE 7,5 ng/mL, cT1c. TAC y cintigrama óseo sin metástasis. **¿Cuáles son las dos opciones curativas estándar?**

A Prostatectomía radical o radioterapia externa

B Quimioterapia con docetaxel o deprivación androgénica exclusiva

C Vigilancia activa o cistectomía radical

D Resección transuretral o tamsulosina

E Inmunoterapia o castración quirúrgica inmediata

Respuesta A. Riesgo intermedio localizado en un paciente con larga expectativa de vida: prostatectomía radical o radioterapia externa, con sobrevida equivalente. La elección depende de los efectos secundarios.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 73 años con cáncer de próstata metastásico óseo inicia leuprolide intramuscular mensual. **¿Por qué se prescribe bicalutamida los primeros 14 días?**

A Prevenir la hepatotoxicidad aguda del leuprolide

B Bloquear el brote inicial de testosterona que puede causar dolor óseo y compresión medular

C Acelerar la eliminación renal del leuprolide

D Evitar la hiponatremia por ADH

E Prevenir la necrosis avascular de la cabeza femoral

Respuesta B. Los agonistas de GnRH producen un aumento transitorio de LH y testosterona los primeros 7 a 14 días (flare up). En metástasis vertebrales puede causar dolor intenso, retención urinaria o compresión medular, y se bloquea con un antiandrógeno.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 82

Un paciente de 85 años se realiza un antígeno prostático específico, que resulta 10 mg/dl, razón por la cual es sometido a una biopsia prostática transrectal, que se informa como “presencia de adenocarcinoma prostático, Gleason 3+3, presente en el 0,5% del tejido. El estudio de diseminación resulta negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Prostatectomía radical

B Radioterapia

C Observar

D Braquiterapia

E Hormonoterapia

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Observar (opción C).

▶ VER CLASE 4.03.1.003

Cáncer de vejiga y urotelio

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.12 · Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV

QUÉ HAY QUE SABER

- Carcinoma urotelial (>90%): principal factor de riesgo el tabaco (riesgo 3–4 veces), además aminas aromáticas (tinturas, caucho), ciclofosfamida y radiación pélvica.
- Sospecha: hematuria macroscópica total, indolora, intermitente y con coágulos en fumador mayor de 50 años; que ceda sola no lo descarta. Síntomas irritativos refractarios sugieren carcinoma in situ.
- Primeras medidas: urocultivo para descartar ITU, función renal y derivación a urología para uro-TAC con fase excretora y cistoscopía (examen que confirma).
- La resección transuretral es diagnóstica y terapéutica; la muestra debe incluir detrusor para definir invasión muscular.
- No músculo invasivo (~75%): RTU + BCG o mitomicina intravesical (recidiva 50–70%); músculo invasivo (≥T2): cisplatino neoadyuvante y cistectomía radical.
- Seguimiento: derivar; requiere cistoscopías periódicas por el especialista. Hematuria con retención por coágulos: sonda 3 vías e irrigación.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 159

Paciente femenina, fumadora de 30 paquetes/año, presenta hematuria, con abundante coágulos de sangre. No presenta dolor, fiebre, ni otros síntomas. Se solicita un sedimento de orina, que muestra abundantes eritrocitos, sin bacterias. El diagnóstico más probable es: **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Cistitis hemorrágica

B Cáncer de vejiga

C Cáncer renal.

D Tuberculosis renal

E Infección urinaria

Respuesta B. El cáncer de vejiga es la causa más frecuente de hematuria monosintomática en el adulto, en especial en un fumador. Las otras opciones tienen otros síntomas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 62 años operado de resección transuretral de una masa vegetante vesical. La biopsia informa carcinoma urotelial de alto grado que infiltra la lámina propia, con músculo detrusor indemne en la muestra (T1). **¿Cuál es el tratamiento adyuvante de elección?**

A Cistectomía radical inmediata con conducto ileal

B Instilaciones intravesicales con BCG

C Radioterapia pélvica externa

D Quimioterapia sistémica MVAC por 6 ciclos

E Observación sin terapia adicional

Respuesta B. Es un cáncer no músculo invasivo T1 de alto riesgo. Tras la resección completa, el tratamiento adyuvante estándar para reducir la recidiva y la progresión es el BCG intravesical. La cistectomía se reserva para falla del BCG o invasión muscular.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 77

Un paciente de 67 años, fumador de 20 cigarrillos diarios, consulta por hematuria de 4 días de evolución, abundante, con coágulos. No ha presentado disuria, ni poliaquiuria, ni mal olor en la orina, ni dolor. Su examen de orina muestra abundantes eritrocitos por campo, sin

A Cáncer renal
B Cáncer de vejiga
C Cáncer de uréter
D Cáncer de próstata
E Cistitis intersticial

Respuesta B. La hematuria monosintomática del adulto sugiere un cáncer de vejiga. El antecedente de fumar, también.

▶ VER CLASE 4.03.1.004 Criptorquídea

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.10 · Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical

QUÉ HAY QUE SABER

- Criptorquidia: testículo que no está en el escroto ni se logra descender; diferenciar del testículo retráctil, que sí baja con la maniobra y no requiere cirugía.
- El descenso espontáneo ocurre casi siempre en los primeros 6 meses; examinar en cada control del lactante, con manos tibias y paciente relajado.
- Confirmación clínica: palpable (canal inguinal) o no palpable; la ecografía no es necesaria para decidir la cirugía.
- Bilateral no palpable, sobre todo con pene pequeño o hipospadias: descartar trastorno de diferenciación sexual (cariograma, 17-OH-progesterona y electrolitos por HSC perdedora de sal).
- Conducta: derivar a cirugía infantil para orquidopexia, idealmente entre 6 y 18 meses, para preservar fertilidad, facilitar el autoexamen y reducir riesgo de torsión.
- Seguimiento: riesgo de cáncer testicular 4–10 veces mayor aunque se opere; controles con examen testicular y enseñar autoexamen en la adolescencia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 9 meses en control de salud. Desde el nacimiento no se palpa el testículo derecho en el escroto; se palpa en el canal inguinal y no logra descenderse al escroto con maniobras suaves. El testículo izquierdo está en posición normal. Pene y meato normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Observar hasta los 5 años, porque puede descender espontáneamente
B Orquiectomía derecha inmediata
C Tratamiento con gonadotrofina coriónica como terapia de elección y control en la pubertad
D Derivar a cirugía infantil para orquidopexia, idealmente antes de los 12 a 18 meses de vida
E Tranquilizar porque es un testículo retráctil

Respuesta D. El descenso espontáneo ocurre casi siempre en los primeros 6 meses. Un testículo no descendido después de esa edad se deriva para orquidopexia, idealmente entre los 6 y 18 meses, para preservar la fertilidad, facilitar el autoexamen y disminuir el riesgo de cáncer y torsión. El testículo retráctil, en cambio, sí desciende con la maniobra.

▶ VER CLASE 4.03.1.005 Disfunción sexual de causa orgánica

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.16 · Patología Peneana: Fimosis, Parafimosis, Balanopostitis, Priapismo & Disfunción Eréctil

QUÉ HAY QUE SABER

- Disfunción eréctil: incapacidad persistente (≥3 meses) de lograr o mantener una erección suficiente; la causa orgánica más frecuente es vascular (aterosclerosis), además diabetes, neuropatía, fármacos e hipogonadismo.
- Orienta a orgánica: inicio gradual, pérdida de erecciones matinales/nocturnas, factores de riesgo cardiovascular; es marcador precoz de enfermedad coronaria.
- Estudio: glicemia o HbA1c, perfil lipídico, testosterona total matinal (y LH/prolactina si está baja); revisar fármacos (tiazidas, betabloqueadores, ISRS, antiandrógenos).
- Tratamiento inicial: manejo de factores de riesgo (tabaco, obesidad, actividad física) e inhibidores de PDE5: sildenafil 50 mg 1 h antes o tadalafilo 10–20 mg a demanda (5 mg diario).
- Contraindicación absoluta: nitratos (hipotensión grave); precaución con alfabloqueadores y cardiopatía inestable.
- Seguimiento: control de respuesta y riesgo cardiovascular; derivar a urología si no responde a PDE5, hay enfermedad de Peyronie o hipogonadismo.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 112

Hombre de 55 años con disfunción eréctil de 6 meses de evolución, sin causa aparente. HTA controlada con enalapril. Sin síntomas de hipogonadismo. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A Inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (sildenafil o tadalafil)

B Testosterona intramuscular

C Alprostadil intracavernoso

D Prótesis de pene

E Solo consejería psicológica

Respuesta A. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 son la primera línea en la disfunción eréctil orgánica (vascular, diabética). Están contraindicados con nitratos. La testosterona solo si hay hipogonadismo demostrado; alprostadil y prótesis son segunda y tercera línea. La disfunción eréctil es además un marcador de riesgo cardiovascular que debe evaluarse.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 49

Un paciente de 63 años consulta por impotencia sexual de algunos meses de evolución, que ha avanzado. Tiene antecedente de diabetes de 20 años de evolución. Está preocupado, ya que le ha provocado problemas maritales. El tratamiento más adecuado es:

A Inyecciones intracavernosas de papaverina

B Yohimbina

C Sildenafil

D Prótesis peneana

E Psicoterapia

Respuesta A. Es una pregunta difícil, ya que el sildenafil está contraindicado por el infarto reciente. De primera línea está el sildenafil, la apomorfina y los dispositivos de vacío (no recuerdo si salía apomorfina). De segunda línea, están las inyecciones intracavernosas de papaverina o prostaglandina. La última línea es la prótesis peneana. La yohimbina y la protsglandina tópica sirven, pero poco.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 32

Un paciente de 68 años, con antecedente de hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial y diabetes, está en tratamiento con tamsulosina, atenolol, hidroclorotiazida, metformina y aspirina. Consulta por dificultades para lograr y mantener la erección, lo que le preocupa. ¿Qué fármaco puede ser el causante de estos síntomas?

A Aspirina

B Metformina

C Hidroclorotiazida

D Tamsulosina

E Atenolol

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Atenolol (opción E). Ahora ya saben, el atenolol puede producir impotencia sexual.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 107

Paciente adulto mayor que no lograba erección, libido se conservaba, temor a que su pareja lo deje ya que antes tenían encuentros 1-2 por semana. Conducta:

A Sildenafil

B Búsqueda de causa 2ria: tenía líbido conservada, no describe ansiedad ante su performance, me parece relevante descartar causas secundarias (p ej diabetes) antes de asumir q su problema es psicológico c. Terapia psicológica (justifiquen cada una)

C Trastorno de ansiedad generalizada

D Trastorno obsesivo compulsivo

E Trastorno de estrés postraumático

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Sildenafil (opción A).

▶ VER CLASE 4.03.1.006 **Enfermedades de transmisión sexual** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.6 · Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Uretritis gonocócica: secreción purulenta abundante, incubación 2–7 días; Gram con diplococos Gram negativos intracelulares. No gonocócica (Chlamydia): secreción escasa, 'gota matinal', Gram solo con PMN.
- Toda uretritis: doble cobertura por coinfección 20–40%: ceftriaxona 500 mg IM dosis única + doxiciclina 100 mg c/12 h por 7 días (o azitromicina 1 g oral). Ciprofloxacino no, por resistencia del gonococo.
- Úlcera indolora, indurada, de fondo limpio con adenopatía indolora: sífilis primaria, penicilina benzatina 2.400.000 UI IM dosis única. Vesículas dolorosas en racimo: herpes, aciclovir 400 mg c/8 h 7–10 días.
- Úlcera dolorosa, sucia, con bubón: chancroide, azitromicina 1 g oral o ceftriaxona 250 mg IM. Condilomas (VPH 6 y 11): podofilotoxina, imiquimod o crioterapia.
- Ante toda ITS: tamizaje de VIH, sífilis y hepatitis B; tratar a los contactos de los últimos 60 días y abstinencia por 7 días; notificación obligatoria de las que corresponda.

- Seguimiento: control clínico y serológico (VDRL a los 3, 6 y 12 meses en sífilis), consejería en preservativo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años consulta por una úlcera en el glande de 10 días, indolora, de bordes indurados y fondo limpio, de 1 cm, con adenopatías inguinales bilaterales firmes e indoloras. Tuvo relaciones sexuales sin preservativo hace 4 semanas. No es alérgico a medicamentos. VDRL reactivo 1:16. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Penicilina benzatina 2.400.000 UI intramuscular por una vez, más estudio de VIH y tratamiento de la pareja

B Aciclovir 400 mg cada 8 horas por 7 días

C Ceftriaxona 500 mg intramuscular más doxiciclina

D Azitromicina 1 g oral por una vez

E Penicilina sódica endovenosa por 14 días

Respuesta A. Úlcera genital única, indolora e indurada, con adenopatías inguinales indoloras, es un chancro de sífilis primaria. El tratamiento es penicilina benzatina 2.400.000 UI intramuscular en dosis única, con notificación, estudio de VIH y otras ITS, y tratamiento de los contactos. La penicilina sódica endovenosa es para neurosífilis.

▶ VER CLASE **4.03.1.007** **Epididimitis** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.6 · Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Epididimitis: dolor escrotal subagudo (1–3 días), escroto rojo y caliente, fiebre y síntomas urinarios; epidídimo engrosado desde la cola, Prehn positivo y reflejo cremastérico conservado.
- La edad decide el germen: menor de 35 años sexualmente activo, Chlamydia y gonococo; mayor de 35 o con patología prostática, E. coli y entéricos.
- Menor de 35: ceftriaxona 500 mg IM dosis única + doxiciclina 100 mg c/12 h por 10–14 días y tratar a la pareja.
- Mayor de 35: ciprofloxacino 500 mg c/12 h o levofloxacino 500 mg/día por 10–14 días y estudiar la vía urinaria baja (HPB, obstrucción). Siempre reposo, suspensorio y AINE.
- Ante duda con torsión (adolescente, inicio brusco, cremastérico abolido): exploración quirúrgica.
- Seguimiento: si persiste fiebre a las 48–72 h, eco Doppler para buscar absceso o infarto (derivar a urología para drenaje).

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 179

Un paciente de 60 años fue tratado hace 7 días con ciprofloxacino, por disuria. Hace dos días presenta dolor testicular izquierdo, asociado a fiebre. Al examen físico tiene aumento de volumen testicular, con dolor a la palpación, especialmente del conducto espermático. Se observa ligero edema escrotal, con eritema. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hidrocele

B Varicocele

C Torsión testicular

D Tumor testicular

E Orquiepididimitis

Respuesta E. Un varón de 60 años con infección urinaria reciente, fiebre y dolor testicular con edema y eritema escrotal: orquiepididimitis clásica. Se distingue de la torsión por la edad, la fiebre y el inicio subagudo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 175

Un paciente de 65 años consulta por dolor escrotal derecho de 3 días de evolución. Al examen físico presenta dolor y eritema en la zona escrotal derecha y se palpa aumento de volumen y dolor, del testículo y del epidídimo. Refiere tener pareja sexual monogámica. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Streptococcus pyogenes

B Staphilococcus aureus

C Chlamydia trachomatis

D Neisseria gonorreae

E Escherichia coli

Respuesta E. En mayores de 35 años, y sin conducta sexual de riesgo, la orquiepididimitis la causa más frecuente es E. coli, por reflujo desde la vía urinaria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 161

Un paciente de 21 años, sexualmente activo, consulta por dolor y aumento de volumen progresivos en relación al testículo izquierdo, que inició hace 5 días y se ha asociado a disuria y escasa secreción uretral. Al examen físico, presenta frecuencia cardíaca 65 latidos por minuto, presión arterial 110/70 mmHg y temperatura axilar de 37,1 °C. El examen genital muestra escroto aumentado de volumen y enrojecido a izquierda; se palpa testículo izquierdo ligeramente aumentado de volumen, sin masas, y epidídimo izquierdo con gran aumento de volumen, muy doloroso a la palpación. **¿Qué tratamiento es el más adecuado?**

A Ceftriaxona intramuscular

B Ciprofloxacino oral

C Amoxicilina con ácido clavulánico oral

D Doxiciclina oral

E Exploración quirúrgica

Respuesta D. Orquiepididimitis con uretritis en un joven sexualmente activo, de curso subagudo y con escasa secreción: lo más probable es Chlamydia, que se trata con doxiciclina. En la práctica se cubren ambos gérmenes, con ceftriaxona más doxiciclina.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 26 años, sexualmente activo sin preservativo, consulta por dolor progresivo en el hemiescroto derecho de 48 horas, con sensación febril y ardor al orinar. T° 37,9 °C. Hemiescroto tumefacto y caliente, epidídimo derecho engrosado y muy sensible. Reflejo cremastérico presente. Al elevar el testículo, el dolor se alivia. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Exploración quirúrgica urgente

B Ceftriaxona 500 mg IM más doxiciclina 100 mg cada 12 horas

C Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas en monoterapia

D Reposo y AINE sin antibiótico

E Doppler y esperar el resultado antes de tratar

Respuesta B. Epididimitis aguda en un menor de 35 años sexualmente activo: Prehn positivo y reflejo cremastérico presente. Se toman muestras y se inicia esquema dual con ceftriaxona y doxiciclina, más reposo, suspensorio y tratamiento de la pareja.

▶ VER CLASE 4.03.1.008 Estenosis uretral

DX SOSPECHA · TX INICIAL · SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.2 · Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Estenosis uretral: disminución progresiva del calibre y fuerza del chorro, disuria de esfuerzo, goteo e ITU recurrente en hombre joven o con antecedente de trauma perineal o pelviano, instrumentación, RTU o uretritis.
- Se sospecha cuando la sonda no progresa (típicamente en uretra bulbar) o produce uretrorragia; no forzar el sondeo.
- Estudio: uroflujometría (Qmáx bajo con curva aplanada en meseta) y uretrografía retrógrada, que define ubicación y longitud.
- Retención aguda con sonda imposible: cistostomía suprapúbica por punción.
- Seguimiento: derivar a urología para uretrotomía interna o uretroplastía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 55

Paciente masculino de 30 años consulta por disminución del calibre miccional, asociada a disuria de esfuerzo de varios meses de evolución. Tiene antecedente de un trauma perineal hace 3 años. Al examen físico tiene genitales externos normales y su tacto rectal demuestra una próstata pequeña y blanda. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Cáncer de próstata

B Uretritis

C Hiperplasia prostática benigna

D Estenosis uretral

E Urolitiasis

Respuesta D. Un hombre joven con chorro débil progresivo y antecedente de trauma perineal (lesión de uretra bulbar) tiene una estenosis uretral hasta demostrar lo contrario. Se estudia con uroflujometría y uretrografía retrógrada. La HPB ocurre en mayores y con próstata aumentada de tamaño.

▶ VER CLASE 4.03.1.009 Fimosis, parafimosis

DX ESPECÍFICO · TX INICIAL · SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.16 · Patología Peneana: Fimosis, Parafimosis, Balanopostitis, Priapismo & Disfunción Eréctil

QUÉ HAY QUE SABER

- Fimosis: imposibilidad de retraer el prepucio; es fisiológica en el lactante y preescolar y se resuelve espontáneamente en la mayoría; no se debe retraer a la fuerza.
- Patológica: anillo cicatricial blanquecino (liquen escleroso), balanitis o ITU recurrentes, o 'globo' prepucial con dificultad miccional.
- Tratamiento inicial: corticoide tópico (betametasona 0,05% 2 veces al día por 4–8 semanas) con retracción suave; circuncisión si fracasa o hay fimosis cicatricial o complicaciones.

- Parafimosis: prepucio retraído que no vuelve y forma anillo constrictor con edema del glande, típicamente tras sonda o examen; es urgencia: compresión del edema, analgesia y reducción manual.
- Seguimiento: control de respuesta al corticoide y derivar a cirugía/urología para circuncisión electiva cuando corresponda (incluida la parafimosis ya reducida).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 62

Niño de 5 años con incapacidad de retraer el prepucio sobre el glande. Sin dolor ni infecciones previas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Circuncisión electiva inmediata
B Tranquilizar: fimosis fisiológica normal hasta los 6-7 años; observar
C Corticoides tópicos en el prepucio
D Derivar a urología
E Dilatación manual bajo anestesia

Respuesta B. La fimosis fisiológica es normal en la infancia y se resuelve espontáneamente en la mayoría. Sin balanitis recurrente, ITU, cicatriz (fimosis patológica) ni globo prepucial con obstrucción, se observa. La retracción forzada está contraindicada porque produce fisuras y fimosis cicatricial. Si persiste o hay síntomas, los corticoides tópicos son la primera opción.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 114

Un niño de 3 años acude a control sano. Su madre refiere que tiene estrechez del prepucio y, al examen físico, se confirma que el prepucio es irreductible . ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Aplicar ungüento antibiótico
B Realizar tracción manual forzada del prepucio
C Realizar circuncisión
D Aplicar ungüento de corticoide tópico
E Controlar en un año

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Aplicar ungüento de corticoide tópico (opción D).

▶ VER CLASE 4.03.1.010 Hematuria

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Urología 13.12 · Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV
Urología 13.15 · Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Hematuria microscópica: ≥3 GR por campo (400x) en 2 de 3 sedimentos; la tira reactiva da falsos positivos (mioglobina, hemoglobina) y debe confirmarse con sedimento.
- Glomerular: orina té/coca-cola, sin coágulos, GR dismórficos >80% o acantocitos >5%, cilindros hemáticos y proteinuria: derivar a nefrología.
- Urológica: roja, con coágulos (descartan origen glomerular), GR isomórficos y sin proteinuria; causas litiasis, cáncer, HPB, infección.
- Banderas rojas de cáncer urotelial: >50 años (o >35–40 con riesgo), tabaco >10 paquetes-año, aminas aromáticas, irradiación pélvica, hematuria macroscópica previa.
- Conducta inicial: urocultivo; si es urológica, derivar para uro-TAC con fase excretora y cistoscopía. Microhematuria aislada en niño: repetir el examen antes de estudiar.
- Seguimiento: derivar a urología o nefrología según el origen.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 65 años, fumador de 30 cigarrillos diarios por 40 años. Hace 5 días tuvo orina francamente roja con coágulos alargados durante toda la micción, indolora, que cedió en 24 horas. Examen físico normal. Sedimento con hematuria sin leucocitos ni proteinuria. **¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico más probable?**

A Antígeno prostático específico
B Cistoscopía
C Urocultivo y antibióticos empíricos
D Radiografía simple de abdomen
E Observación, porque cedió solo

Respuesta B. Hematuria macroscópica indolora con coágulos en un fumador adulto mayor es cáncer de vejiga hasta demostrar lo contrario. Que ceda solo no lo descarta. Se confirma con cistoscopía y resección transuretral.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 62 años, jubilado de una fábrica de pinturas y fumador de 25 paquetes-año. Asintomático, con microhematuria en un control preventivo. Sedimento: 35 a 40 glóbulos rojos por campo, 95% isomórficos, sin acantocitos ni cilindros. Proteinuria negativa, urocultivo estéril, creatinina 0,8 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Derivar a nefrología para biopsia renal

B Derivar a urología para uro-TAC y cistoscopía

C Repetir el examen en un año

D Indicar antibióticos empíricos

E Solicitar C3, C4 y ANCA

Respuesta B. Es una microhematuria urológica (isomórfica, sin cilindros ni proteinuria) con riesgo oncológico alto: más de 50 años, tabaquismo y exposición laboral a aminas aromáticas. Se estudia con uro-TAC con fase excretora y cistoscopía.

▶ VER CLASE 4.03.1.011 Hidrocele

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.7 · Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes

QUÉ HAY QUE SABER

- Hidrocele: líquido entre las hojas de la túnica vaginal; masa escrotal indolora, lisa, que rodea al testículo (no se palpa aparte), transilumina y permite palpar el cordón por encima.
- En el lactante suele ser comunicante (persistencia del conducto peritoneovaginal) y se resuelve espontáneamente antes de 1–2 años; si varía de tamaño o persiste, cirugía.
- En el adulto siempre ecografía testicular: confirma y descarta hidrocele secundario a tumor o infección.
- Tratamiento: observar si es asintomático; hidrocelectomía si es grande o molesta. No puncionar (recidiva rápida e infección).
- Seguimiento: control clínico; masa que no transilumina o testículo no evaluable obliga a ecografía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años consulta por aumento de volumen del hemiescroto izquierdo, indoloro, de crecimiento lento en 1 año. Al examen se palpa una masa quística, lisa, que no permite palpar bien el testículo, transilumina y no se reduce. Se puede palpar el cordón espermático por encima de la masa. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Punción evacuadora repetida como tratamiento definitivo

B Ecografía testicular para confirmar el diagnóstico y descartar una causa secundaria, como tumor o infección, y luego cirugía electiva si es sintomático

C Herniorrafia inguinal urgente

D Orquiectomía inguinal radical

E Antibióticos por 14 días

Respuesta B. Una masa quística que transilumina, envuelve al testículo y permite palpar el cordón por encima es un hidrocele. En el adulto siempre se solicita ecografía, porque el testículo no se palpa bien y el hidrocele puede ser secundario a tumor o infección. Si molesta, se trata con hidrocelectomía; la punción tiene alta recidiva.

▶ VER CLASE 4.03.1.012 Hidronefrosis

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.2 · Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Hidronefrosis: dilatación de la pelvis y cálices por obstrucción (litiasis, estenosis pieloureteral, tumor, HPB, compresión extrínseca) o reflujo; si es bilateral orienta a obstrucción infravesical.
- Sospechar ante dolor lumbar, masa en flanco, ITU recurrente o injuria renal aguda/postrenal; en la IRA el primer paso es descartar obstrucción con ecografía renal y vesical.
- Hidronefrosis sin dilatación ureteral sugiere estenosis pieloureteral; con dilatación ureteral, obstrucción distal o reflujo.
- Urgencia: hidronefrosis infectada (fiebre) o riñón único/anuria: descompresión urgente con catéter doble J o nefrostomía percutánea, además de antibióticos.
- Obstrucción baja con globo vesical: sonda Foley y vigilar diuresis postobstructiva (>1.000 mL evacuados: poliuria e hipokalemia).
- Seguimiento: derivar a urología; cintigrama MAG3/DTPA con diurético para obstrucción y función diferencial.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 74

Paciente de 18 años consulta por dolor lumbar izquierdo de larga evolución. Al examen físico tiene una masa en el flanco izquierdo. La ecografía abdominal muestra hidronefrosis izquierda con adelgazamiento de la corteza renal, sin dilatación ureteral. Su creatinina plasmática es 0,9 mg/dL y su sedimento de orina es normal. La cintigrafía renal muestra función diferencial de 90% a derecha y 10% a izquierda. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar pieloplastía izquierda

B Realizar nefrostomía percutánea

C Realizar nefrectomía izquierda

D Instalar sonda Foley

E Solicitar pieloTAC

Respuesta C. Hidronefrosis sin dilatación ureteral indica estenosis pieloureteral. Con corteza adelgazada y función diferencial de 10% o menos en la cintigrafía, el riñón se considera no recuperable y sintomático: se indica nefrectomía. Si la función estuviera conservada, la conducta sería pieloplastía. La nefrostomía es solo una medida transitoria de drenaje.

▶ VER CLASE 4.03.1.013

Hiperplasia prostática benigna

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.3 · Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP

QUÉ HAY QUE SABER

- HPB: nace en la zona de transición; síntomas de vaciado (chorro débil, latencia, goteo) y de llenado (nicturia, polaquiuria, urgencia). El tamaño no se correlaciona con los síntomas.
- Evaluación: IPSS (0–7 leve, 8–19 moderado, 20–35 severo), tacto rectal (próstata aumentada, lisa, elástica, indolora; nódulo pétreo sugiere cáncer), sedimento, creatinina y APE.
- Tratamiento: leve, observación y hábitos; moderado-severo, tamsulosina 0,4 mg/día (efecto en 48–72 h, no cambia volumen ni APE; eyaculación retrógrada, hipotensión ortostática, iris flácido en cirugía de cataratas).
- Próstata >40 cc: agregar finasteride 5 mg/día o dutasteride (reducen volumen 20–25% en 3–6 meses y el APE a la mitad: multiplicar por 2).
- Indicaciones absolutas de cirugía: retención aguda refractaria o repetida, ITU recurrente, litiasis vesical, hematuria prostática recurrente, divertículos o daño renal; RTUP si <80 cc. Cirugía de HPB sintomática tiene garantía GES.
- Seguimiento: control de síntomas con IPSS, residuo postmiccional y función renal; evitar anticolinérgicos y antihistamínicos que precipitan retención.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 8

Un paciente de 50 años, diabético en tratamiento con metformina, consulta por poliaquiuria, nicturia, latencia y debilidad del chorro miccional desde hace meses, no asociado a otros síntomas. Su tacto rectal muestra próstata aumentada de tamaño de consistencia gomosa. Con respecto a este caso, **¿Cuál de las siguientes es una indicación absoluta para resolución quirúrgica en esta patología?**

A Hematuria en una ocasión

B Retención aguda de orina

C Residuo postmiccional de 150 ml

D Prostata mayor a 40 cc

E Antígeno prostático de 5 ng/ml

Respuesta B. Es una HPB. La retención urinaria aguda es indicación absoluta de cirugía. Hematuria en una ocasión y residuo de 150 ml son indicaciones relativas. El APE elevado solo es indicación de biopsia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 80

Un paciente de 70 años, con antecedente de hiperplasia prostática benigna, consulta por escapes de grandes cantidades de orina, asociada a deseos intensos de ir al baño. Se solicita una ecografía vesicoprostática que visualiza adenoma prostático de 50 cc de volumen, vejiga urinaria con paredes engrosadas y residuo postmiccional significativo **¿Cuál es la indicación más adecuada?**

A Imipramina oral

B Tamsulosina oral

C Amitriptilina oral

D Tolterodina oral

E Cloruro de trospio

Respuesta B. HPB con complicaciones y escapes de orina por rebalse. El alfabloqueante es el tratamiento de primera línea para la HPB con síntomas obstructivos y residuo postmiccional significativo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 71 años en tratamiento con Finasteride 5 mg/día desde hace 1 año por HPB. En su control anual asintomático, el laboratorio informa un APE total sérico de 2.8 ng/mL. El tacto rectal no revela nódulos. **¿Cómo debe interpretarse el valor real de su APE sérico para fines de screening de cáncer de próstata?**

A El valor real es 2.8 ng/mL y se considera normal para su edad

B El valor real es 5.6 ng/mL y se encuentra en zona de sospecha oncológica

C El valor real es 1.4 ng/mL debido a la sobrestimación por tiazidas

D El valor del APE es inválido y debe suspenderse el finasteride por 1 mes para repetir

E El finasteride no altera el valor plasmático del APE

Respuesta B. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa reducen el APE en 50% a partir de los 6 meses de uso continuo. Para interpretarlo, se duplica el valor informado: 2,8 por 2 son 5,6 ng/mL, que cae en la zona de sospecha y exige estudio.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años con 2 años de nicturia 4 a 5 veces, chorro débil y entrecortado y sensación de vaciamiento incompleto. IPSS 22. Sin globo vesical. Tacto rectal: próstata de 55 cc, lisa, de bordes netos, fibroelástica, sin nódulos. APE 2,4 ng/mL, creatinina 0,9 mg/dL y sedimento normal. Residuo postmiccional de 130 mL. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A Tamsulosina más finasteride

B Resección transuretral urgente

C Ciprofloxacino por 2 semanas

D Biopsia prostática

E Oxibutinina

Respuesta A. HPB con síntomas severos y próstata de más de 40 cc, con tacto rectal y APE benignos y sin complicaciones orgánicas. Se parte con tratamiento médico: un alfa uno bloqueante, que actúa rápido, junto a un inhibidor de la 5-alfa reductasa, que frena el crecimiento. La cirugía no está indicada todavía, ni la biopsia, porque el APE y el tacto son normales.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 104

Un paciente de 65 años, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril y diabetes mellitus en tratamiento con metformina y glibenclamida, presenta desde hace 3 meses y en forma progresiva, poliaquiuria y nicturia, asociado a latencia, chorro miccional doble y débil. Al examen físico se palpa próstata aumentada de tamaño de consistencia gomosa. Se solicita antígeno prostático que resulta en 3,5ng/ml. La conducta más adecuada en este caso es:

A Realizar prostatectomía vía resección transuretral

B Realizar prostatectomía por vía retropúbica

C Indicar alfa agonista

D Indicar inhibidor de la 5 alfa reductasa

E Indicar análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas

Respuesta A. El paciente tiene síntomas obstructivos e irritativos de hiperplasia prostática benigna con antígeno prostático normal. El tratamiento inicial sería farmacológico con alfabloqueadores, pero entre las alternativas la única conducta aceptable es la resección transuretral, ya que el llamado alfa agonista no corresponde al fármaco correcto. Los inhibidores de la 5 alfa reductasa tardan meses en actuar y los análogos de GnRH no tienen indicación en la hiperplasia prostática benigna.

▶ VER CLASE 4.03.1.014 Incontinencia urinaria

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.4 · Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica

QUÉ HAY QUE SABER

- Incontinencia de esfuerzo: escape en pequeños chorros con tos, risa o salto, sin deseo previo (falla del cierre, multíparas). Urgencia: deseo imperioso que no da tiempo, con nicturia (detrusor hiperactivo).
- Rebalse: goteo continuo sin deseo, con residuo postmiccional >200 mL (HPB avanzada, estenosis o vejiga neurogénica diabética). Siempre medir residuo y pedir sedimento y urocultivo.
- Esfuerzo: ejercicios de Kegel supervisados por kinesiólogo 8–12 semanas; si fracasa, cinta suburetral TOT/TVT (éxito >85%). Los anticolinérgicos no sirven.
- Urgencia: reentrenamiento vesical, evitar cafeína y tabaco; oxibutinina 5 mg c/8–12 h, tolterodina (menos boca seca) o mirabegrón 50 mg/día (preferido en ancianos).
- Rebalse: aliviar la obstrucción o cateterismo intermitente limpio; nunca anticolinérgicos. Mixta: tratar la que predomina.
- Seguimiento: derivar a urología/uroginecología si es mixta refractaria, hay prolapso, residuo alto o se plantea cirugía (urodinamia previa).

PREGUNTAS · 9

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 101

Mujer de 56 años con escapes de orina en grandes cantidades, precedidos por deseos incontrolables de orinar. También presenta escapes en la noche. Al examen no hay pérdida con la maniobra de Valsalva. Urocultivo negativo y sedimento normal. La ecografía muestra vejiga de paredes delgadas, sin cálculos ni residuo postmiccional. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Iniciar tamsulosina
B Iniciar oxibutinina
C Realizar cistoscopía
D Realizar suspensión uretral con cinta transvaginal
E Indicar ejercicios de kinesioterapia pélvica

Respuesta B. El escape precedido por deseo urgente, sin relación con el esfuerzo, y con Valsalva negativo, es incontinencia de urgencia. El tratamiento inicial es conductual y farmacológico con anticolinérgicos como la oxibutinina; la cirugía no tiene rol aquí.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 121

Una paciente de 60 años presenta incontinencia urinaria de 2 años de evolución, caracterizada por escapes de orina precedidos por urgencia miccional incontrolable, por lo que utiliza 3 a 5 protectores al día. Su examen físico es normal, al igual que su exploración ginecológica. Se solicita una ecografía abdominal que muestra vía urinaria de calibre normal y vejiga urinaria sin lesiones, con residuo postmiccional de 30 cc. **¿Qué fármaco es más adecuado como tratamiento de primera línea?**

A Bloqueadores alfa adrenérgicos
B Bloqueadores beta adrenérgicos
C Agonistas adrenérgicos
D Anticolinérgicos muscarínicos
E Estrógenos

Respuesta D. Urgencia miccional con residuo normal: incontinencia de urgencia. Tras las medidas conductuales y el entrenamiento vesical, el fármaco clásico son los antimuscarínicos (oxibutinina, tolterodina). El mirabegrón (agonista beta-3) se prefiere si hay deterioro cognitivo o riesgo de delirium.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 76

Una mujer de 65 años de edad, multípara de 4, con todos los partos por vía vaginal, con menopausia a 50 años, sin terapia de reemplazo hormonal, presenta escape de pequeñas cantidades de orinal, al realizar esfuerzos, así como al toser o reírse, lo que la obliga a usar protectores. No tiene urgencia miccional. Su examen físico no aporta mayor información, pero es posible visualizar leve escape de orina, al toser. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea para esta paciente?**

A Cirugía (TVT)
B Anticolinérgicos
C Alfa adrenérgicos
D Kinesioterapia del piso pélvico
E Antibióticos, como profilaxis de ITU

Respuesta D. Pérdidas pequeñas con tos, risa y esfuerzos, sin urgencia, en multípara posmenopáusica: incontinencia de esfuerzo. Primera línea: kinesioterapia del piso pélvico (Kegel); la cirugía TVT o TOT queda si fracasa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 48

Una paciente de 69 años diabética, mal controlada, presenta escapes de orina. Además ha presentado algunas infecciones urinarias. Su urocultivo actual está negativo, pero consulta por la incontinencia urinaria. Se realiza una ecografía que muestra una vejiga de paredes lisas, con volumen urinario de 930cc y residuo postmiccional de 750cc. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Resolver quirúrgicamente
B Instalar una sonda Foley
C Realizar cateterismo intermitente
D Indicar anticolinérgicos
E Indicar colinérgicos

Respuesta C. Residuo postmiccional muy elevado en una diabética mal controlada: incontinencia por rebose por vejiga acontráctil (neuropatía diabética). Se trata con cateterismo limpio intermitente; los anticolinérgicos están contraindicados.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 79

Una mujer de 73 años, presenta escapes de orina, precedidos por grandes e incontrolables deseos de orinar. Además, ha tenido escapes de orina en la noche. Al examen físico, no hay mayores alteraciones. Se solicita una ecografía vesical, que visualiza una vejiga urinaria de paredes delgadas, sin litiasis y sin residuo postmiccional significativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar cistoscopía
B Realizar suspensión uretral con cinta transvaginal
C Iniciar oxibutinina
D Indicar ejercicios de piso pélvico
E Realizar cirugía abierta de piso pélvico

Respuesta C. Escapes precedidos por deseo imperioso, con residuo normal: incontinencia de urgencia. Se trata con anticolinérgicos, como la oxibutinina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 49

Una paciente de 81 años, multípara de 3, histerectomizada, inicia escapes de orina de esfuerzos hace 5 años y además, desde hace 2 años tiene escapes de urgencia. No tiene antecedente de infecciones urinarias, ni hematuria. Al examen físico se aprecia un grado leve de prolapso genital. Se realiza sedimento de orina con 4-5 leucocitos por campo y 2-3 hematíes por campo, sin bacterias y se realiza un urocultivo, que resulta negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar tratamiento quirúrgico del prolapso
B Indicar ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico
C Iniciar anticolinérgicos
D Iniciar alfabloqueadores adrenérgicos
E Solicitar ecografía abdomino-pélvica

Respuesta B. Es una incontinencia mixta en que predomina el esfuerzo, y el sedimento y el urocultivo descartan infección. Se parte con ejercicios del suelo pélvico.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 54 años, con tres partos vaginales, consulta por escapes de orina de un año, en chorros pequeños al toser, reír o saltar. No tiene urgencia ni nicturia. Hay un cistocele grado I y sale orina por el meato al toser. Residuo postmiccional por ecografía: 15 mL. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Oxibutinina 5 mg cada 8 horas
B Ejercicios de suelo pélvico con kinesiólogo
C Cinta transobturatriz de inmediato
D Cateterismo intermitente limpio
E Mirabegrón 50 mg al día

Respuesta B. Es una incontinencia de esfuerzo no complicada, con residuo normal. La primera línea son los ejercicios de Kegel supervisados por kinesiólogo durante 8 a 12 semanas. La cinta suburetral queda para el fracaso o el escape severo. Los anticolinérgicos y el mirabegrón son para urgencia, y el cateterismo para rebalse.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 71

Una paciente de 37 años presenta escapes de orina, en grandes cantidades, precedidos por deseos incontrolables de orinar. Su examen físico no aporta mayor información. Su urocultivo es negativo y su desimento de orina no presenta alteraciones. Se solicita una cistomanometría que muestra contracciones no inhibidas del detrusor, que aparecen entre los 80 y 100 cc de llenado vesical. El tratamiento inicial más adecuado es:

A Anticolinérgicos
B Bloqueadores alfa 1 adrenérgicos
C Cirugía
D Kinesioterapia pélvica
E Reducación vesical

Respuesta A. Es una pregunta muy discutible, ya que, si bien está claro que tiene una incontinencia urinaria de urgencia, tanto los anticolinérgicos, como la terapia conductual (reeducación vesical sería lo más similar a ello) son tratamientos adecuados. Como se pregunta el tratamiento inicial, yo marqué la E, siguiendo las recomendaciones norteamericanas. Pero, la verdad, es que aquello es discutido por las asociaciones de especialistas luego de conversarlo mucho con varios especialistas, ellos recomiendan...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 112

Paciente adulta mayor con cuadro clásico de incontinencia urinaria de esfuerzo, conducta: a. Kinesioterapia pélvica

A Amoxicilina
B Ibuprofeno
C Paracetamol
D Omeprazol
E Metformina

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Amoxicilina (opción A).

▶ VER CLASE 4.03.1.015 Infección urinaria alta y baja

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.4 · Pielonefritis Aguda e Infecciones Urinarias Altas en el Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Cistitis: disuria, polaquiuria y urgencia, nunca fiebre. Pielonefritis: fiebre >38,5 °C con calofríos, dolor lumbar y puñopercusión positiva; puede faltar la clínica baja en ancianos.
- Cistitis no complicada en mujer joven: no requiere urocultivo; nitrofurantoína 100 mg c/12 h por 5 días (alternativas fosfomicina 3 g dosis única o cefalosporina oral).
- Pielonefritis: urocultivo con antibiograma antes del antibiótico; ambulatoria: ciprofloxacino 500 mg c/12 h por 7 días o cefalosporina oral 10–14 días. Nitrofurantoína y fosfomicina no sirven en pielonefritis.
- Hospitalizar si hay embarazo, intolerancia oral, sepsis, obstrucción o falla renal, o inmunosupresión: ceftriaxona 1–2 g/día EV (BLEE o shock: ertapenem/meropenem). Embarazo: ceftriaxona, nunca quinolonas.
- Bacteriuria asintomática: tratar solo en embarazadas y antes de procedimientos urológicos con sangrado de mucosa.

- Seguimiento: control a las 48–72 h; sin respuesta con germen sensible, TAC o ecografía para buscar absceso u obstrucción. Cistitis recurrente poscoital: orinar tras el coito y profilaxis poscoital.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 6

Se atiende a una paciente de 26 años con antecedente de infecciones del tracto urinario a repetición desde hace 4 años, coincidiendo con el inicio de sus relaciones sexuales. Ha presentado urocultivos positivos para Escherichia coli con una frecuencia de 5 a 6 episodios por año. Su examen físico actual es normal, el urocultivo es negativo y el panel de PCR para infecciones de transmisión sexual también resulta negativo. Una ecografía renal y vesical previa resultó normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar cistoscopía
B Solicitar PCR para Mycobacterium tuberculosis en orina
C Iniciar flavoxato vía oral
D Profilaxis antibiótica poscoital
E Indicar uso de preservativo durante las relaciones sexuales

Respuesta D. Cistitis recurrente (3 o más al año) claramente asociada al coito, con ecografía normal, se maneja con profilaxis antibiótica poscoital en dosis única (nitrofurantoína o cotrimoxazol). En mujeres jóvenes sin factores de complicación no se requieren cistoscopía ni más estudio. El flavoxato es solo un antiespasmódico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 108

Mujer de 25 años con infecciones urinarias recurrentes (>3 episodios/año) claramente asociadas a relaciones sexuales. ¿Cuál es la profilaxis más adecuada?

A Nitrofurantoína 50 mg o cotrimoxazol post coito
B Ciprofloxacino 500 mg diario indefinido
C Amoxicilina 500 mg diario
D Solo higiene y micción postcoital
E Vacuna anti-E. coli

Respuesta A. ITU recurrente postcoital: profilaxis antibiótica postcoito con una dosis única de nitrofurantoína 50-100 mg o cotrimoxazol 480 mg reduce recurrencias en >95% de los casos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 93

Mujer de 55 años con ITU a repetición (>3 episodios/año) que recibe profilaxis con nitrofurantoína. Tiene antecedente de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuál es el cambio terapéutico más adecuado?

A Amoxicilina profiláctica
B Cefalexina profiláctica
C Cotrimoxazol profiláctico
D Suspender profilaxis y observar
E Mantener nitrofurantoína sin cambios

Respuesta C. Nitrofurantoína está contraindicada en fibrosis pulmonar (puede agravar la enfermedad pulmonar y causa toxicidad pulmonar crónica). Cambio a cotrimoxazol (trimetoprim-sulfametoxazol) profiláctico postcoital o cíclico es la alternativa de elección para ITU recurrente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 4

Pregunta 4 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un paciente se realiza una cirugía transuretral hace 7 días. Evoluciona con disuria dolorosa, asociada a malestar general y fiebre hasta 38,7 grados Celsius. Se realiza un sedimento de orina con leucocituria de 50 por campo y abundantes bacterias, y un urocultivo, que resulta positivo para Pseudomona aureginosa y el antibiograma está pendiente. El tratamiento de elección es:

A Amoxicilina-clavulánico
B Nitrofurantoína
C Cotrimoxazol
D Imipenemen
E Ceftriaxona

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Imipenemen (opción D). De las opciones que aparecían, el imipenem era el único con cobertura para Pseudomona.

▶ VER CLASE 4.03.1.016 Infección urinaria específica

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.3 · Tuberculosis: Formas Extrapulmonares, Diagnóstico y Manejo MDR

QUÉ HAY QUE SABER

- Tuberculosis urogenital: forma extrapulmonar por siembra hematógena; síntomas irritativos persistentes, hematuria y piuria estéril (leucocituria con urocultivo convencional negativo) en orina ácida.
- Sospechar ante 'ITU' que no responde a antibióticos, antecedente de TBC, inmunosupresión o epididimitis crónica con fístula escrotal.
- Confirmación: baciloscopía y cultivo de Koch en 3 a 6 muestras seriadas de primera orina matinal, o PCR (GeneXpert); uro-TAC muestra estenosis ureterales, calcificaciones y vejiga retraída.

- Tratamiento inicial: esquema nacional 2RHZE/4RH directamente observado, notificación y estudio de contactos; ante masa de pelvis renal o duda diagnóstica, derivar.
- Seguimiento: derivar a urología por secuelas (estenosis ureteral, hidronefrosis, vejiga contraída) que requieren manejo especialista.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años, con antecedente de tuberculosis pulmonar tratada hace 10 años, consulta por disuria, polaquiuria y hematuria intermitente de 4 meses. Ha recibido 2 cursos de antibióticos sin mejoría. El sedimento urinario muestra leucocituria abundante con orina ácida, y los urocultivos convencionales han sido repetidamente negativos. **¿Cuál es el estudio más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A Urocultivo con antibiograma nuevamente
B Citología urinaria
C Cultivo de orina para Mycobacterium tuberculosis (Koch) en muestras seriadas de primera orina de la mañana
D PCR para Chlamydia trachomatis en orina
E Ecografía testicular

Respuesta C. La piuria estéril (leucocituria con urocultivo convencional negativo) con orina ácida, hematuria y síntomas irritativos persistentes sugiere tuberculosis urogenital, más aún con antecedente de TBC. Se confirma con baciloscopía y cultivo de Koch en al menos 3 a 6 muestras seriadas de la primera orina matinal (o PCR para M. tuberculosis), y se estudia con uroTAC.

▶ VER CLASE 4.03.1.017 Infertilidad masculina

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.7 · Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida

QUÉ HAY QUE SABER

- Infertilidad: falta de embarazo tras 12 meses de relaciones sin protección (6 meses si la mujer tiene ≥35 años); el factor masculino participa en alrededor de un tercio de los casos y se estudia siempre en pareja.
- Primer examen: espermiograma con 3–5 días de abstinencia; si sale alterado, se repite a las 4–12 semanas antes de concluir.
- Buscar causas: varicocele (la causa tratable más frecuente), criptorquidia, orquitis urliana, ITS, fármacos/anabólicos, tabaco y calor; examen testicular (volumen y consistencia).
- Azoospermia con testículos pequeños y firmes, ginecomastia y LH/FSH altas: hipogonadismo primario, probable Klinefelter (cariograma); LH/FSH bajas: hipogonadismo central.
- Medidas iniciales: suspender anabólicos, tabaco y alcohol, control de peso; derivar a urología/andrología con espermiograma alterado confirmado.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 75

Hombre de 33 años, lleva 18 meses intentando concebir un hijo con su pareja. Ella tiene reglas regulares. Él tiene examen físico y genital normal. **¿Con qué examen debemos iniciar el estudio en este paciente?**

A Hormona luteinizante
B Hormona folículo estimulante
C Espermiograma
D Cultivo de líquido seminal
E Ecografía testicular

Respuesta C. El primer examen del estudio de infertilidad masculina es siempre el espermiograma, sin importar que el examen físico sea normal. Las hormonas o la imagen se piden solo si el espermiograma resulta alterado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 43

Una pareja consulta por infertilidad de 2 años de evolución. Ella no tiene anteceden- tes de importancia y tanto su examen físico, como exploración ginecológica son norma- les. Él realiza ciclismo de montaña y en su examen físico se constatan testículos de ta- maño pequeño, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el primer examen para evaluarlo?

A Espermiograma
B Ecografía testicular
C Niveles plasmáticos de LH, FSH y testosterona
D Niveles plasmáticos de TSH, prolactia
E Biopsia testicular

Respuesta A. El espermiograma es el examen de elección para el inicio del estudio de la infertili- dad masculina.

▶ VER CLASE 4.03.1.018 Lesiones quísticas del riñón

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.14 · Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante

QUÉ HAY QUE SABER

- Quiste renal simple: hallazgo frecuente y benigno (>50% en mayores de 50 años); criterios ecográficos: anecogénico, pared fina, redondo con borde nítido y refuerzo acústico posterior.
- Si cumple los criterios (Bosniak I): tranquilizar y dar de alta sin seguimiento. Si tiene tabiques, calcificaciones o ecos: TAC con contraste y clasificar con Bosniak.
- Bosniak II benigno; IIF (~5% malignidad) control con TAC a los 6 y 12 meses; III (50–60%) y IV (85–100%) son quirúrgicos: derivar.
- Poliquistosis renal autosómica dominante (PKD1 85%, PKD2): riñones grandes bilaterales, HTA precoz, hematuria, quistes hepáticos e historia familiar; progresa a insuficiencia renal.
- Manejo PQRAD: presión <130/80 con IECA/ARA-II; cefalea súbita 'la peor de su vida' sugiere rotura de aneurisma de Berry (8–10%): TAC de cerebro urgente; angio-RM si hay historia familiar.
- Seguimiento: quiste simple sin control; PQRAD con control de PA, función renal y derivación a nefrología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 54 años asintomática, ecografía de chequeo: en el polo superior del riñón izquierdo hay una lesión anecogénica de 3,8 cm, redondeada, de paredes delgadas e imperceptibles, con refuerzo acústico posterior nítido y sin tabiques ni calcificaciones. Examen físico y función renal normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tranquilizar a la paciente y darle el alta sin seguimiento

B TAC de abdomen y pelvis con contraste para descartar malignidad

C Punción percutánea aspirativa para citología

D Repetir la ecografía cada 6 meses por 3 años

E Derivar para quistectomía laparoscópica electiva

Respuesta A. Cumple todos los criterios de quiste simple benigno (Bosniak I): anecogénico, pared imperceptible, refuerzo posterior, sin tabiques. No requiere TAC, punción ni controles seriados.

▶ VER CLASE 4.03.1.019 Malformaciones congénitas nefrourológicas

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.13 · Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Malformaciones nefrourológicas (CAKUT): principal causa de ERC en niños; incluyen hidronefrosis por estenosis pieloureteral, reflujo vesicoureteral, megauréter, valvas uretrales posteriores, riñón multiquístico, agenesia y ectopia.
- Sospecha: pielectasia en ecografía prenatal, ITU febril (sobre todo en lactantes), masa abdominal, chorro débil o retraso miccional en recién nacido varón.
- Valvas uretrales posteriores: RN varón con hidroureteronefrosis bilateral y vejiga de lucha; sonda vesical precoz y derivación urgente (resección endoscópica).
- Estudio inicial: ecografía renal y vesical en todo niño con primera ITU febril o pielectasia prenatal; uretrocistografía miccional si la eco es anormal o la ITU es atípica/recurrente.
- Manejo inicial: tratar la ITU y considerar profilaxis antibiótica en dilataciones importantes o reflujo de alto grado.
- Seguimiento: derivar a nefrología o urología infantil; cintigrama DMSA para cicatrices y MAG3 para obstrucción.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 20

Un recién nacido de sexo masculino, con antecedente de pielectasia bilateral diagnosticada por ecografía obstétrica, presenta retraso en la eliminación de orina. La ecografía abdominal al tercer día de vida muestra hidroureteronefrosis bilateral asociada a una vejiga de paredes engrosadas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Valvas uretrales posteriores

B Síndrome de Prune Belly

C Reflujo vésico-ureteral

D Vejiga neurogénica

E Megauréter congénito

Respuesta A. Hidroureteronefrosis bilateral con vejiga de paredes engrosadas (de lucha) en un recién nacido varón con micción retrasada es una obstrucción infravesical: valvas uretrales posteriores. Se confirma con uretrocistografía miccional (uretra posterior dilatada) y se maneja con sonda vesical y resección endoscópica. El megauréter suele ser unilateral y sin vejiga de lucha.

▶ VER CLASE 4.03.1.020 Quistes del epidídimo

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.7 · Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes

QUÉ HAY QUE SABER

- Quiste de epidídimo/espermatocele: masa lisa, indolora, en la cabeza del epidídimo (polo superior), separada y extratesticular, que transilumina; el espermatocele contiene líquido lechoso con espermatozoides.
- Confirmación: ecografía testicular muestra lesión líquida bien delimitada extratesticular; toda masa intratesticular sólida es cáncer hasta demostrar lo contrario.
- Tratamiento: observación si es asintomático (son benignos); resección quirúrgica (espermatocelectomía) solo si duele o es grande.
- No puncionar ni hacer orquiectomía por un quiste de epidídimo.
- Seguimiento: control clínico o ecográfico; consultar si crece o aparece dolor.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 124

Un paciente de 18 años, asintomático, se palpa un tumor intraescrotal derecho, por lo que consulta. Al examen físico se palpa una tumoración extratesticular de 1,5 cm de diámetro, de consistencia elástica, indolora a la palpación. Se solicita ecografía escrotal que muestra parénquima testicular de aspecto normal, sin lesiones y se visualiza una lesión hipoecogénica de paredes finas, de 1,5 cm de diámetro, en relación con la cabeza del epidídimo derecho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar orquiectomía radical

B Realizar resección quirúrgica de la lesión del epidídimo

C Realizar punción de la lesión

D Indicar autoexamen testicular frecuente

E Controlar ecográficamente en un año

Respuesta E. Parece un quiste del epidídimo. Suele observarse. El autoexamen testicular no cuenta con evidencia y la mayoría no lo recomienda.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 82

Un paciente de 21 años, sin antecedentes, mientras jugaba futbol sufre golpe en zona testicular tras lo cual se palpa una masa. Al examen físico se palpa masa en polo superior blanda. Se solicita ecografía escrotal que muestra lesión quística en epidídimo de 3 cm de diámetro, sin otros hallazgos. La conducta más adecuada en este caso es:

A Orquiectomía por vía inguinal

B Punción y aspiración del quiste

C Orquiectomía por vía escrotal

D Observación

E Indicar inhibidores de la 5 alfa reductasa

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Observación (opción D). Es un quiste del epidídimo. Se observan.

▶ VER CLASE 4.03.1.021 Reflujo vésico ureteral

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.13 · Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Reflujo vesicoureteral: paso retrógrado de orina de la vejiga al uréter; es la malformación más asociada a ITU febril en niños y causa cicatrices renales (nefropatía por reflujo).
- Sospecha: ITU febril recurrente, ecografía con dilatación pielocalicial o ureteral, o hidronefrosis prenatal; hermanos de pacientes con reflujo.
- Diagnóstico específico: uretrocistografía miccional, fuera de la fase aguda, que lo clasifica en grados I a V; se pide si la ecografía está alterada o la ITU es atípica/recurrente.
- Daño parenquimatoso: cintigrama DMSA 4–6 meses después de la pielonefritis para detectar cicatrices.
- Manejo inicial: tratar cada ITU con urocultivo por sondeo, profilaxis antibiótica (nitrofurantoína o cefadroxilo en dosis baja nocturna) en reflujo de alto grado o ITU recurrente; manejo de disfunción vesical e intestinal.
- Seguimiento: controles de urocultivo ante fiebre, PA y crecimiento renal; derivar a nefrología/urología infantil (corrección endoscópica o quirúrgica si hay ITU de brecha o daño progresivo).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 8 meses cursa su segundo episodio de pielonefritis aguda por E. coli. La ecografía renal muestra dilatación pielocalicial bilateral leve. La uretrocistografía miccional muestra reflujo vésico-ureteral grado IV bilateral. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Profilaxis antibiótica continua y derivación a nefrología o urología infantil, con cintigrama DMSA para evaluar cicatrices

B Cirugía de reimplante ureteral inmediata

C Alta sin seguimiento, ya que el reflujo se resuelve siempre espontáneamente

D Repetir la uretrocistografía en 1 semana

E Tratamiento antibiótico solo durante los episodios febriles

Respuesta A. El RVU de alto grado (IV a V) con ITU febril recurrente en un lactante tiene alto riesgo de cicatrices renales. Se indica profilaxis antibiótica (nitrofurantoína o cefadroxilo), DMSA diferido para evaluar daño parenquimatoso y manejo por especialista; la corrección endoscópica o quirúrgica se reserva para ITU de brecha o daño progresivo.

▶ VER CLASE 4.03.1.022 Tumor renal

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.11 · Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Carcinoma de células renales (células claras ~80%): varón de 50–70 años, tabaco, obesidad, HTA; Von Hippel-Lindau (gen VHL).
- Hoy más del 65% es incidentaloma en ecografía o TAC; la tríada de Guyon (dolor en flanco, hematuria, masa palpable) indica enfermedad avanzada.

- Paraneoplásicos: hipercalcemia por PTHrP (medir PTH), policitemia por eritropoyetina, HTA por renina y síndrome de Stauffer (colestasis sin metástasis hepática).
- Masa renal sólida: TAC trifásico con contraste; realce >15–20 UH se presume cáncer y se opera sin biopsia de rutina. Varicocele derecho o que no colapsa en decúbito obliga a buscar tumor renal.
- Tratamiento (especialista): nefrectomía parcial en T1 (≤7 cm), radical en tumores grandes o centrales; avanzado con antiangiogénicos/inmunoterapia (es resistente a quimio y radioterapia).
- En niños, masa en flanco con hematuria sugiere tumor de Wilms: no palpar repetidamente y derivar. Seguimiento: derivar a urología.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 46

Un paciente de presenta dolor abdominal en el flanco izquierdo, por lo que se realiza una ecografía abdominal, que muestra un tumor renal sólido, de 2,5 cm de diámetro, en el polo superior del riñón derecho. Se solicita un TAC, que confirma el tumor renal de aspecto sólido y que capta contraste. ¿Cuál es la conducta más adecuada? **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Nefrectomía radical

B Nefrectomía parcial

C Nefroureterectomía

D Iniciar inhibidores de la tirosinasa

E Realizar seguimiento ecográfico

Respuesta B. Todo tumor renal sólido que capta contraste se presume cáncer renal. Si es pequeño, se hace nefrectomía parcial; la radical es para los grandes. La nefroureterectomía es para tumores de la pelvis renal.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 56 años, fumador, hipertenso. Una ecografía pedida por dispepsia muestra una masa sólida de 3,5 cm en la corteza del polo superior del riñón izquierdo. Está asintomático, con creatinina normal y orina normal. El TAC trifásico muestra realce marcado, sin invasión de la vena renal ni adenopatías. **¿Cuál es la conducta de elección?**

A Biopsia percutánea de la masa

B Nefrectomía parcial

C Nefrectomía radical con linfadenectomía

D Sunitinib

E Controles ecográficos cada 6 meses

Respuesta B. Masa sólida con realce franco, T1a, periférica y sin metástasis: carcinoma de células renales. La conducta curativa es la nefrectomía parcial, que preserva función renal. No se biopsia de rutina.

▶ VER CLASE 4.03.1.023 **Tumor suprarrenal** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.15 · Feocromocitoma y Paragangliomas: Bloqueo Alfa Obligatorio

QUÉ HAY QUE SABER

- Feocromocitoma: tumor de células cromafines; crisis paroxísticas de cefalea, sudoración profusa y palpitaciones con HTA (tríada con especificidad >90%); hasta 35–40% hereditario (NEM 2, VHL, NF1, SDH).
- Confirmar primero con bioquímica: metanefrinas libres plasmáticas o fraccionadas en orina de 24 h; si son normales prácticamente se descarta. La imagen (TC o RM) va después.
- Incidentaloma suprarrenal: todo requiere estudio funcional con supresión con 1 mg de dexametasona (Cushing subclínico) y metanefrinas; aldosterona/renina si hay HTA o hipokalemia. <10 UH sugiere adenoma.
- Sospechar malignidad si >4 cm, heterogéneo, >10 UH con lavado lento o crecimiento; no biopsiar (peligroso si es feocromocitoma).
- Tratamiento inicial del feocromocitoma: bloqueo alfa primero (doxazosina 2–16 mg/día o fenoxibenzamina) 10–14 días con sal y líquidos; betabloqueador solo después. Nunca betabloqueo solo (crisis hipertensiva).
- Seguimiento: derivar a endocrinología y cirugía; metanefrinas anuales tras la cirugía y estudio genético familiar.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una paciente de 40 años presenta episodios paroxísticos frecuentes de cefalea severa, sudoración profusa y taquicardia con cifras tensionales de 220/115 mmHg. Se confirma el diagnóstico de feocromocitoma suprarrenal derecho mediante metanefrinas fraccionadas urinarias elevadas y TC abdominal. Se programa una suprarrenalectomía laparoscópica para dentro de dos semanas. **¿Cuál de los siguientes esquemas farmacológicos preoperatorios representa la conducta correcta y obligatoria?**

A Iniciar propranolol oral a dosis plenas de inmediato y asociar fenoxibenzamina 24 horas antes del pabellón

B Iniciar bloqueo alfa-adrenérgico con fenoxibenzamina o doxazosina durante 10 a 14 días, y asociar betabloqueador solo con posterioridad si persiste taquicardia

C Indicar atenolol oral en monoterapia sin administrar bloqueadores alfa

D Administrar sulfato de magnesio en infusión y llevar a pabellón de inmediato sin preparación oral

E Indicar espironolactona asociada a enalapril oral

Respuesta B. Preparación obligatoria: bloqueo alfa completo (fenoxibenzamina o doxazosina) por 10 a 14 días con sal y líquidos para reexpandir el volumen. Solo con el bloqueo alfa establecido se agrega betabloqueador si persiste taquicardia. El betabloqueo previo o aislado deja el alfa-1 sin oposición y precipita una crisis hipertensiva.

▶ VER CLASE 4.03.1.024 Tumor testicular

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.10 · Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer testicular: tumor sólido más frecuente en hombres de 15–35 años; >95% germinales (seminoma 50–55%); principal factor de riesgo la criptorquidia (4–10 veces).
- Sospecha: masa intratesticular dura, pétrea e indolora que no transilumina; toda masa intratesticular es maligna hasta demostrar lo contrario.
- Primer examen: ecografía testicular Doppler (sensibilidad cercana al 100%) y marcadores antes de operar: AFP, beta-hCG y LDH. AFP elevada indica no seminoma (el seminoma puro nunca la eleva).
- Tratamiento inicial: derivar para orquiectomía inguinal radical con clampeo alto del cordón; prohibidas la punción y la vía escrotal (cambian el drenaje linfático).
- Etapificación con TAC de tórax, abdomen y pelvis; criopreservar semen antes de la quimioterapia (BEP). Curación >90% incluso avanzado; tiene garantía GES.
- Seguimiento: derivar a urología/oncología; controles con marcadores e imágenes por el especialista.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 162

Un paciente de 30 años consulta por aumento de volumen escrotal derecho. Al examen físico se palpa un tumor en relación al testículo derecho. Se solicita ecografía testicular que visualiza una lesión sólida, de 3 cm de diámetro, sin vascularización, que reemplaza al parénquima testicular, sin compromiso del epidídimo. ¿Cuál es la conducta? **¿Cuál es la conducta?**

A Radioterapia

B Quimioterapia

C Orquiectomía radical

D TAC de abdomen y pelvis

E Biopsia testicular por punción

Respuesta C. Tumor testicular confirmado con la ecografía: orquiectomía radical, que es a la vez diagnóstica y terapéutica. La punción está prohibida; el TAC se pide después para etapificar.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 25 años con aumento de volumen indoloro del testículo derecho de 2 meses. Masa pétrea de 3,5 cm intratesticular, que no transilumina. La ecografía Doppler muestra una masa sólida hipoecogénica vascularizada de 34 mm. AFP 120 ng/mL (normal <8), beta-hCG 45 mUI/mL y LDH 380 U/L. **¿Cuál es la conducta inicial?**

A Biopsia por punción transescrotal

B Orquiectomía inguinal radical con clampeo alto del cordón

C Enucleación del nódulo por vía escrotal

D Ecografía de control en 3 meses

E Quimioterapia con BEP antes de cirugía

Respuesta B. Masa sólida intratesticular con marcadores elevados: tumor germinal no seminomatoso. Se opera por vía inguinal con clampeo alto del cordón. La punción o la vía escrotal están contraindicadas por la diseminación a los ganglios inguinales.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años operado de orquiectomía inguinal. La biopsia informa "seminoma clásico puro", pero la alfafetoproteína es de 350 ng/mL (normal <8) antes y después de la cirugía. **¿Cuál es la implicancia clínica?**

A Es normal: la mitad de los seminomas puros secretan AFP

B El seminoma puro nunca produce AFP; se debe tratar como no seminoma

C La AFP se debe a necrosis tumoral y no cambia la conducta

D Indica insuficiencia hepática por la anestesia

E Indica un teratoma maduro benigno

Respuesta B. El seminoma puro no sintetiza AFP. Si está elevada, hay un componente no seminomatoso no identificado (embrionario o saco vitelino) y el paciente se trata como no seminoma, que es radiorresistente y requiere quimioterapia.

▶ VER CLASE 4.03.1.025 Urolitiasis

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.1 · Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Litiasis urinaria: oxalato de calcio 75–80% (radiopaco); ácido úrico radiolúcido (gota, orina ácida); estruvita coraliforme por Proteus (ureasa, orina alcalina); cistina en cistinuria.
- Sospecha: cólico lumbar súbito irradiado a genitales, inquietud sin posición antiálgica, vómitos, puñopercusión positiva y microhematuria. Diferencial clave en adulto mayor: aneurisma aórtico roto.
- Examen de elección: pielo-TAC (TAC sin contraste), sensibilidad y especificidad >95%; ecografía en embarazadas y niños.
- Conducta inicial según tamaño: <5 mm expulsión espontánea en 80–90% (AINE y filtrar orina); 5–10 mm terapia expulsiva con tamsulosina 0,4 mg/día por hasta 4 semanas; >10 mm derivar (LEOC, ureteroscopía o nefrolitotomía percutánea si >20 mm o coraliforme).
- Banderas rojas: fiebre (pionefrosis), monorreno, anuria o dolor refractario: descompresión urgente con doble J o nefrostomía.
- Prevención: ingesta de agua >2,5 L/día para todos; estudio metabólico (orina 24 h) en recurrentes, monorrenos, niños o cálculos no cálcicos; hipercalciuria: tiazida. Seguimiento: derivar a urología si no expulsa.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 150

Un paciente de 45 años presenta un cuadro de cólico renal derecho que es manejado con analgesia. Se realiza una pieloTAC, que muestra la presencia de un cálculo de 4 mm en el uréter derecho, el cual se maneja inicialmente con observación. Sin embargo, luego de 4 semanas no ha presentado expulsión del cálculo a pesar de haberse indicado terapia expulsiva con alfabloqueantes hace dos semanas. La pieloTAC de control muestra mayor dilatación de la vía urinaria en dicha zona, con presencia del cálculo descrito, de 4 mm en el uréter distal, que se informa con una dureza de 800 unidades de Hounsfield. La creatinina de control está en 1,38 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener terapia farmacológica expulsiva y controlar en 2 semanas

B Realizar la instalación de un catéter “doble J”

C Administrar antibióticos endovenosos

D Realizar una ureteroscopía

E Realizar litotricia (litotripsia) extracorpórea

Respuesta D. Si el cálculo no sale tras cuatro semanas y la vía se dilata más, hay que resolverlo. La ureteroscopía se prefiere para cálculos del uréter distal y muy duros, y cuando la litotripsia extracorpórea no corresponde. La litotripsia se prefiere en uréter alto o medio, de dureza baja o moderada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 126

Un paciente de 54 años ha presentado varios episodios de cólico renal, con eliminación reiterada de cálculos urinarios. Su examen físico no tiene alteraciones. En sus exámenes destaca creatinina: 1,4 mg/dl y examen de orina con pH: 7,9, glóbulos rojos: 15 x campo, glóbulos blancos: 15 por campo, bacterias en moderada cantidad y cristales de fosfato amónico magnésico (estruvita). El pieloTAC muestra presencia de cálculos coraliformes bilaterales. **¿Qué germen es el agente etiológico, con mayor probabilidad?**

A Proteus mirabilis

B Klebsiella oxytoca

C Pseudomona aureginosa

D Campilobacter jejuni

E Escherichia coli

Respuesta A. El Proteus es la causa de los cálculos coraliformes de estruvita. Además, suele alcalinizar la orina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 64

Un paciente de 34 años presenta su primer episodio de cólico renal. Presenta eliminación espontánea de un pequeño cálculo, el que no es preservado para estudio citoquímico. Actualmente está asintomático y el pieloTAC no observa otras litiasis. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este paciente?**

A Indicar dieta baja en lácteos

B Iniciar hidroclorotiazida

C Aumentar la ingesta de agua

D Realizar litotripsia extracorpórea

E Realizar estudio metabólico de urolitiasis

Respuesta C. Para evitar la recidiva de las litiasis siempre es útil aumentar la ingesta de agua, con independencia de la causa. Además, en los casos de hipercalciuria sirven las tiazidas y, en los casos de hiperoxaluria o hiperuricosuria, sirve la dieta. En el caso de ser por estruvita, también se debe tratar con antibióticos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 170

Un paciente de 42 años presenta eliminación de un cálculo en orina, el cual no pudo recuperar para análisis. Se realiza estudio metabólico en orina de 24 horas con calcio, fósforo, citrato y uratos, todos dentro del rango normal, al igual que su perfil bioquímico en sangre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Aumentar la ingesta de agua

B Iniciar alopurinol oral

C Realizar litrotricia extracorpórea

D Indicar dieta baja en lácteos

E Indicar dieta rica en vegetales

Respuesta A. Prevención de la Litiasis Urinaria: La medida más importante para prevenir la formación de cálculos renales es aumentar la ingesta de agua. Dependiendo del tipo de cálculo y las alteraciones metabólicas, se pueden recomendar medidas adicionales como tiazidas para la hipercalciuria, alopurinol para la hiperuricemia/hiperuricosuria, y una dieta baja en proteínas animales para la hiperoxaluria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 11

Un paciente de 78 años ha presentado eliminación de cálculos urinarios a repetición. Se solicitan exámenes de orina que muestran sedimento con 20 glóbulos rojos por campo, 12 leucocitos por campo, bacterias en abundante cantidad y cristales abundantes de fosfato de amonio magnesiano. El urocultivo está pendiente. Se solicita una pieloTAC, que muestra cálculos coraliformes bilaterales. El urocultivo, probablemente resultará positivo, ¿para qué bacteria?

A Pseudomona aureginosa

B Escherichia coli

C Campilobacter jejuni

D Proteus mirabilis

E Enterobacter cloacae

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Campilobacter jejuni).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 48

Un paciente de 83 años, diabético e hipertenso, consulta por dolor en el flanco derecho, asociado a 2 episodios de vómitos alimentarios. En su examen físico, tiene frecuencia cardíaca: 80x', PA: 120/80 mmHg y abdomen sin signos peritoneales. Se solicita TAC de abdomen y pelvis que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Colitis isquémica

B Pancreatitis aguda

C Litiasis ureteral

D Diverticulitis aguda

E Infarto esplénico

Respuesta C. Diagnóstico Diferencial de Cólico Renal: El cuadro clínico sugiere un cólico renal. Sin embargo, en un paciente adulto mayor con factores de riesgo cardiovascular, se debe considerar un aneurisma aórtico abdominal roto. En la imagen, se observa un cálculo en el uréter, confirmando el diagnóstico de urolitiasis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 101

Paciente con litiasis a repetición, orina inflamatoria y cristales de fosfato magnesio amónico con litiasis coraliforme. ¿Qué microorganismo crecerá en el urocultivo?

A Escherichia coli

B Klebsiella pneumoniae

C Pseudomonas aeruginosa

D Staphylococcus saprophyticus

E Proteus mirabilis

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Proteus mirabilis). Proteus mirabilis.

▶ VER CLASE 4.03.1.026 Uropatía alta

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Urología 13.1 · Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Uropatía obstructiva alta: obstrucción ureteral o pieloureteral (cálculo, estenosis, tumor, compresión extrínseca por cáncer pélvico) con hidroureteronefrosis; bilateral o en monorreno produce IRA postrenal.
- Diagnóstico específico: pielo-TAC sin contraste para litiasis o ecografía renal (hidronefrosis); TAC con contraste si se sospecha causa tumoral y la función lo permite.
- Obstrucción infectada (fiebre, calofríos, hipotensión): urgencia; hemocultivos, urocultivo, volumen, antibióticos EV y descompresión urgente con catéter doble J o nefrostomía percutánea.
- El tratamiento definitivo del cálculo (LEOC o ureteroscopía) se difiere hasta resolver la infección, porque manipularlo infectado agrava la sepsis.
- Obstrucción ureteral bilateral tumoral sin posibilidad de doble J retrógrado: nefrostomía percutánea.
- Seguimiento: derivar a urología; vigilar poliuria postobstructiva y electrolitos tras desobstruir.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 48 años con dolor lumbar derecho tipo cólico de 2 días, ahora con fiebre de 39 °C, calofríos y PA 95/60 mmHg. La TAC sin contraste muestra un cálculo de 8 mm en el uréter proximal derecho con hidronefrosis moderada. Creatinina 1,6 mg/dL. Se inician hemocultivos, volumen y antibióticos endovenosos. **¿Cuál es la conducta más importante a continuación?**

A Tamsulosina y esperar expulsión espontánea

B Litotricia extracorpórea de urgencia

C Derivación urgente de la vía urinaria (catéter doble J o nefrostomía percutánea)

D Ureteroscopía con extracción del cálculo en el mismo acto

E Completar 14 días de antibióticos y luego reevaluar

Respuesta C. Una pielonefritis obstructiva (uropatía obstructiva alta infectada) es una urgencia urológica: además de antibióticos y soporte, requiere descomprimir la vía urinaria de inmediato con catéter doble J o nefrostomía. El tratamiento definitivo del cálculo (litotricia o ureteroscopía) se difiere hasta resolver la infección, porque manipularlo infectado agrava la sepsis.

▶ VER CLASE 4.03.1.027 Uropatía obstructiva baja

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Urología 13.2 · Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía
Urología 13.3 · Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP

QUÉ HAY QUE SABER

- Uropatía obstructiva baja: obstrucción infravesical por HPB (la más frecuente), cáncer de próstata, estenosis uretral, coágulos, cálculos o vejiga neurogénica; fármacos anticolinérgicos y opiáceos la descompensan.
- Sospecha: síntomas de vaciado, globo vesical, incontinencia por rebalse (goteo continuo) y, si progresa, hidronefrosis bilateral con alza de creatinina (IRA postrenal).
- Primera medida: sonda Foley 16–18 Fr con descompresión continua y completa (el clampeo intermitente está obsoleto); con trauma uretral o sonda imposible, cistostomía suprapúbica.
- Vigilar diuresis postobstructiva si se evacúan >1.000 mL: poliuria, hipovolemia e hipokalemia; controlar diuresis y electrolitos.
- Estudio: ecografía renal y vesicoprostática con residuo postmiccional, creatinina, APE (diferido) y uroflujometría.
- Seguimiento: derivar a urología para tratar la causa (alfabloqueador, cirugía de HPB, uretrotomía).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Varón de 69 años con retención urinaria aguda de 12 horas es sondado con éxito en urgencias mediante sonda Foley, evacuándose de forma inmediata 1.400 mL de orina clara. El paciente refiere alivio inmediato del dolor. **¿Cuál es la complicación fisiopatológica que debe monitorizarse con mayor atención en las primeras 24 horas?**

A Reflejo vasovagal sostenido con paro cardíaco

B Síndrome de diuresis post-obstructiva con deshidratación e hipokalemia

C Estenosis uretral isquémica precoz

D Necrosis tubular aguda anúrica irreversible

E Hematuria ex vacuo masiva con shock hipovolémico

Respuesta B. Tras la descompresión de una obstrucción severa y prolongada, sobre todo con más de 1.000 mL, puede aparecer el síndrome de diuresis postobstructiva: pérdida del gradiente medular y excreción de la urea retenida, con diuresis masiva, deshidratación e hipokalemia. La hematuria ex vacuo con shock es un mito.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 76 años con síntomas urinarios bajos de años, sin tratamiento, consulta por goteo urinario continuo, día y noche, de 2 meses, y decaimiento. Al examen hay un globo vesical palpable indoloro. Creatinina 2,8 mg/dL (hace 1 año 1,0 mg/dL). La ecografía muestra hidroureteronefrosis bilateral y vejiga distendida con 900 mL. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Descompresión vesical con sonda Foley, control de diuresis y electrolitos por riesgo de poliuria postobstructiva, y derivar a urología

B Oxibutinina por incontinencia de urgencia

C Nefrostomía percutánea bilateral urgente

D Iniciar tamsulosina y control en 3 meses

E Biopsia renal por insuficiencia renal de causa desconocida

Respuesta A. El goteo continuo con globo vesical es incontinencia por rebalse, y la hidronefrosis bilateral con alza de creatinina indica uropatía obstructiva baja con daño renal. Se descomprime la vejiga con sonda, vigilando la poliuria postobstructiva y los electrolitos, y luego se trata la causa. La nefrostomía no es necesaria si la obstrucción es infravesical.

▶ VER CLASE 4.03.1.028 Varicocele

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.7 · Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes

QUÉ HAY QUE SABER

- Varicocele: dilatación del plexo pampiniforme, casi siempre izquierdo (vena espermática drena en ángulo recto a la renal izquierda); 'bolsa de gusanos' sobre el testículo, aumenta con Valsalva y se colapsa acostado.
- Es la causa tratable más frecuente de infertilidad masculina (calor e hipoxia dañan la espermatogénesis); no transilumina. Eco Doppler confirma si hay duda.
- Bandera roja: varicocele derecho aislado, de aparición brusca después de los 40 años o que no colapsa en decúbito: TAC de abdomen y pelvis para descartar tumor renal o retroperitoneal.
- Varicocelectomía si hay infertilidad con espermiograma alterado, atrofia testicular (en adolescentes) o dolor persistente; si no, observar.
- Seguimiento: control clínico del volumen testicular en adolescentes y espermiograma en adultos con deseo de fertilidad.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 148

Un adolescente de 15 años presenta dolor frecuente del testículo izquierdo. Al examen físico se palpa aumento de volumen peritesticular, compatible con un varicocele y además se palpa el testículo izquierdo de menor tamaño que el testículo derecho. Se solicita una ecografía testicular que muestra una dilatación patológica del plexo pampiniforme. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Observa evolución hasta que complete su desarrollo puberal

B Realizar varicosectomía

C Solicitar espermiograma

D Realizar biopsia testicular

E Solicitar cariograma y niveles de testosterona, LH y FSH

Respuesta B. Tiene indicación de ligadura del plexo pampiniforme, tanto por la atrofia testicular como por el dolor.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años, sano, nota hace 3 semanas un aumento de volumen indoloro en el hemiescroto derecho. Se palpa una masa varicosa tortuosa en el cordón derecho que, al acostarlo en decúbito dorsal, sigue ingurgitada y no se colapsa. **¿Cuál es la conducta diagnóstica prioritaria?**

A Varicocelectomía subinguinal electiva

B Espermiograma para evaluar fertilidad

C TAC de abdomen y pelvis con contraste

D Tranquilizar: es un proceso benigno por la edad

E Suspensorio escrotal y control en 6 meses

Respuesta C. Varicocele derecho, de aparición tardía y que no se colapsa en decúbito: obstrucción venosa fija hasta demostrar lo contrario. Se busca un carcinoma renal con trombo en la vena renal o la cava, o una masa retroperitoneal, con TAC de abdomen y pelvis.

Situaciones clínicas de urgencia

9 códigos

▶ VER CLASE 4.03.2.001 Cólico renal

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.1 · Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Cólico renal: dolor lumbar súbito, intenso, paroxístico, irradiado a flanco y genitales, con inquietud, vómitos, puñopercusión positiva y microhematuria.
- Confirmación: pielo-TAC (TAC sin contraste), examen de elección; ecografía en embarazadas y niños. No pedir uro-TAC ni urografía para el cólico.
- Analgesia sin esperar el TAC: AINE EV, ketorolaco 30 mg o ketoprofeno 100 mg; opioide (tramadol o morfina) solo de rescate. Evitar sueros rápidos y diuréticos.

- Alta con AINE oral; cálculo 5–10 mm: tamsulosina 0,4 mg/día y control en 2–4 semanas; <5 mm observar y filtrar orina.
- Hospitalizar y descomprimir (doble J o nefrostomía) si hay fiebre, monorreno, anuria/falla renal, dolor refractario o vómitos incoercibles.
- Seguimiento: derivar a urología si no expulsa en 4 semanas, cálculo >10 mm o complicado.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 158

Paciente con hidronefrosis izquierda severa por urolitiasis y antecedente de nefrectomía derecha previa (monorreno). Sin infección activa. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Catéter doble J para aliviar la obstrucción y preservar la función renal

B Nefrectomía izquierda

C Nefrostomía percutánea de urgencia

D Litotricia extracorpórea sin derivación

E Solo analgesia y observar

Respuesta A. Monorreno con obstrucción ureteral por cálculo: es una IRA postrenal y una urgencia urológica. El catéter doble J descomprime el sistema colector y preserva el único riñón funcionante. Observar o litotriptar sin derivar deja al riñón obstruido.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 100

Un paciente de 26 años presenta un cuadro de dolor lumbar, asociado a inquietud motora de 5 día de evolución. Hace 2 días se agrega fiebre y compromiso del estado general, más vómitos alimentarios. Al examen físico se aprecia FC: 105x', PA: 100/70 mmHg, T°: 38°C, puño percusión positiva a izquierda. Se solicita pieloTAC que muestra imagen cálcica en el tercio medio del uréter izquierdo, con dilatación de la vía urinaria proximal y edema perirrenal. Su sedimento de orina muestra 40 leucocitos por campo, bacterias y cristales en moderada cantidad. Se inicia tratamiento antibiótico endovenoso y se administran cristaloides. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Litotripsia extracorpórea

B Nefrolitotomía percutánea

C Extracción quirúrgica abierta

D Catéter doble jota

E Litotomía ureteroscópica

Respuesta D. PNA sobre una vía urinaria obstruida por un cálculo (pionefrosis): emergencia urológica. Además de antibióticos y volumen, hay que descomprimir la vía urinaria, con un catéter doble J (o nefrostomía percutánea si no es posible). El cálculo se trata después, con la infección resuelta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 56

Un paciente de 27 años, sin antecedentes, consulta por dolor en flanco izquierdo de 2 horas de evolución tipo cólico, irradiado a genitales, náuseas y vómitos, sudoración y hematuria. Al examen físico se encuentra inquieto, con puño percusión positiva a izquierda. **El fármaco de elección para el manejo de este paciente es:**

A Ketorolaco

B Acetaminofeno

C Pargeverina

D Tramadol

E Clonixinato de lisina

Respuesta A. Cólico renal: el fármaco de primera línea es un AINE endovenoso, como el ketorolaco.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 33

Un paciente de 32 años presenta un cuadro de cólico renal, asociado a microhematuria en el sedimento de orina. **¿Cuál es el examen de elección para el estudio de este paciente?**

A UroTAC

B PieloTAC

C Pielografía de eliminación intravenosa

D Ecografía

E Radiografía simple

Respuesta B. El cólico renal se estudia con PieloTAC (TAC sin contraste). El UroTAC se utiliza como estudio de la hematuria, después de descartar TU, cuando se sospecha cáncer, ya que dibuja bien la vía urinaria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 27

Un paciente de 22 años presenta un cuadro de dolor a la fosa lumbar derecha, irradiado al flanco derecho intenso ipsilateral y asociado a vómitos, que ha manejado con analgésicos. Evoluciona dos días después con malestar general y fiebre de 38,8°C. Su sedimento de orina muestra Se solicita pieloTAC, que muestra presencia de un cálculo de 9 mm, en el tercio distal del uréter derecho, con presencia de hidroureteronefrosis ipsilateral. **Además de iniciar analgésicos y antibióticos, ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?**

A Realizar nefrolitotomía abierta

B Realizar nefrolitotomía percutánea

C Realizar litotripsia extracorpórea

D Instalar un catéter doble J

E Indicar tratamiento médico expulsor

Respuesta D. Cólico con fiebre e hidroureteronefrosis es una pionefrosis, una urgencia: se descomprime la vía con un catéter doble J. El cálculo se trata después, cuando la infección está controlada.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 34 años consulta por dolor lumbar derecho súbito de 3 horas, irradiado a testículo, con vómitos e intensa inquietud. PA 155/95 mmHg, FC 102 lpm, T° 36,7 °C. Puñopercusión derecha muy dolorosa. Sedimento de orina: 50 a 60 eritrocitos por campo. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Ketorolaco endovenoso y luego pielotac

B Morfina endovenosa y esperar la ecografía

C Hidratación rápida con 2 litros de suero y furosemida

D Urografía de eliminación antes de analgesiar

E Hospitalizar para descompresión con doble J

Respuesta A. Es un cólico renal típico, afebril. La primera línea es un AINE endovenoso, que actúa sobre el mecanismo. Luego se pide pielotac para medir el cálculo. No se difiere la analgesia, no se fuerzan fluidos ni diuréticos en la fase aguda y la descompresión se reserva para fiebre, monorreno, anuria o dolor refractario.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 20

¿Cuál es el examen de elección para el enfrentamiento inicial de un paciente de 22 años, en su primer cuadro de cólico renal, con microhematuria?

A Pielografía de eliminación

B UroTAC

C PieloTAC

D Ecografía renal y vesical

E Radiografía simple

Respuesta C. El diagnóstico de cólico renal es clínico. El pieloTAC es el examen de elección para identificar la ubicación y tamaño del cálculo renal, de modo de determinar si se observa (menor a 1 cm) o si se saca mediante LEC u otra intervención. El UroTAC, en cambio, se usa para estudiar el trauma renal y la hematuria, en que se sospecha cáncer, antes de la cistoscopía.

▶ VER CLASE 4.03.2.002 **Hematuria masiva** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.15 · Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Hematuria masiva: sangrado urinario con coágulos y posible retención por coágulos (globo vesical doloroso) o compromiso hemodinámico; en fumador mayor, pensar en cáncer vesical.
- Otras causas: HPB (hematuria prostática), tumor renal, litiasis, trauma, cistitis actínica o hemorrágica, anticoagulación.
- Manejo: ABC, vías venosas, hemograma, pruebas de coagulación, grupo y transfusión si corresponde; corregir anticoagulación.
- Sonda vesical de 3 vías de grueso calibre (20–24 Fr), lavado manual para evacuar coágulos e irrigación vesical continua con suero fisiológico; una sonda fina se obstruye.
- Si no cede con irrigación: cistoscopía urgente con evacuación de coágulos y fulguración.
- Seguimiento: derivar a urología para estudio etiológico con uro-TAC y cistoscopía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 72 años, fumador, consulta por hematuria macroscópica con coágulos de 12 horas y ahora no puede orinar. Al examen tiene globo vesical doloroso. Está hemodinámicamente estable, Hb 11 g/dL. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Instalar sonda Foley de 2 vías de calibre fino

B Instalar sonda vesical de 3 vías de grueso calibre, evacuar coágulos e iniciar irrigación vesical continua con suero fisiológico

C Cistostomía suprapúbica por punción

D Indicar ácido tranexámico y alta con control urológico

E Cistoscopía diagnóstica ambulatoria en 1 mes

Respuesta B. La hematuria masiva con retención por coágulos se maneja con sonda de 3 vías de grueso calibre (20 a 24 Fr), lavado manual para evacuar coágulos e irrigación continua, además de soporte y corrección de coagulopatía. Una sonda fina se obstruye con coágulos. Luego se estudia la causa (en fumador mayor, descartar cáncer vesical con cistoscopía y uroTAC).

▶ VER CLASE 4.03.2.003 Parafimosis

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.16 · Patología Peneana: Fimosis, Parafimosis, Balanopostitis, Priapismo & Disfunción Eréctil

QUÉ HAY QUE SABER

- Parafimosis: prepucio retraído detrás del glande que no vuelve a su posición y forma un anillo constrictor, con glande edematoso y doloroso; típicamente iatrogénica tras sonda o examen.
- Es una urgencia por riesgo de isquemia del glande (violáceo o necrótico indica gravedad).
- Reducción manual: analgesia (bloqueo peneano o anestesia tópica), compresión sostenida del glande para reducir el edema y luego empujar el glande con los pulgares mientras índices y medios traccionan el prepucio hacia distal.
- Si la reducción fracasa: incisión dorsal del anillo constrictor; no aplicar calor (aumenta el edema).
- Prevención: reponer siempre el prepucio tras sondear o examinar.
- Seguimiento: derivar a urología/cirugía para circuncisión electiva diferida.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 70 años hospitalizado con sonda Foley. Al día siguiente de instalada, la enfermera nota el glande edematoso y violáceo con un anillo prepucial retraído y tenso detrás del glande, muy doloroso. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inicial?**

A Balanitis; antifúngico tópico

B Parafimosis; circuncisión inmediata en todos los casos

C Fimosis; corticoide tópico

D Parafimosis; reducción manual del prepucio previa compresión del edema y analgesia

E Gangrena de Fournier; aseo quirúrgico

Respuesta D. La parafimosis es el prepucio retraído que no vuelve a su posición y forma un anillo constrictor, típicamente iatrogénica tras sonda o examen sin reponer el prepucio. Es una urgencia: se reduce manualmente tras analgesia y compresión del edema; si fracasa, incisión dorsal del anillo. La circuncisión se plantea en forma diferida.

▶ VER CLASE 4.03.2.004 Priapismo

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.16 · Patología Peneana: Fimosis, Parafimosis, Balanopostitis, Priapismo & Disfunción Eréctil

QUÉ HAY QUE SABER

- Priapismo: erección prolongada >4 horas no relacionada con estímulo sexual; el isquémico (bajo flujo) es el más frecuente y es una urgencia: cuerpos cavernosos rígidos y dolorosos, glande blando.
- Causas: drogas vasoactivas intracavernosas, trazodona, antipsicóticos, cocaína, anemia falciforme, leucemia; el no isquémico (alto flujo) sigue a trauma perineal, es indoloro y semirrígido.
- Diagnóstico específico: gasometría de sangre cavernosa (isquémico: sangre oscura, pO2 <30, pH <7,25) o eco Doppler.
- Manejo inicial del isquémico: analgesia, bloqueo peneano, aspiración de cuerpos cavernosos e irrigación con suero; si no cede, fenilefrina intracavernosa con monitorización.
- Después de 24–48 h el riesgo de fibrosis y disfunción eréctil permanente es alto: derivar a urología urgente (shunt quirúrgico si fracasa).
- El no isquémico no es urgencia: derivar a urología (observación o embolización selectiva).

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 62

Hombre de 34 años presenta erección dolorosa desde hace 8 horas. Al examen se corrobora erección completa, con turgencia solo de los cuerpos cavernosos y glande y cuerpo esponjoso blandos. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Aplicar hielo en la zona genital

B Realizar derivación cavernoesponjosa de urgencia

C Administrar atropina intracavernosa

D Administrar analgésicos endovenosos

E Administrar fenilefrina intracavernosa

Respuesta E. Erección dolorosa de más de 4 horas con cuerpos cavernosos rígidos es un priapismo isquémico (de bajo flujo), una urgencia. Se trata con aspiración de sangre de los cuerpos cavernosos e inyección intracavernosa de fenilefrina (agonista alfa). Los shunts quirúrgicos se reservan para el fracaso del manejo intracavernoso.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 66

Un hombre de 34 años presenta erección dolorosa, desde hace 8 horas. Al examen tiene cuerpos cavernosos duros, pero con glande y cuerpos esponjosos blandos. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A Aplicar paños fríos en la zona genital

B Fenilefrina endovenosa

C Vaciamiento quirúrgico de los cuerpos cavernosos.

D Drenaje con suero fisiológico frío intracavernoso

E Fenilefrina intracavernosa Respuesta: (Nota: La imagen se corta antes de mostrar la explicación o la respuesta correcta, pero la conducta inicial para un priapismo isquémico suele ser el drenaje y la inyección de fenilefrina intracavernosa).

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Vaciamiento quirúrgico de los cuerpos cavernosos. (opción C). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 94

Un paciente de 24 años, con antecedente de consumo frecuente de cocaína, presenta dolor peneano de 5 horas de evolución asociado a una erección constante. Al examen físico se objetiva erección de los cuerpos cavernosos, con flacidez del glande y el cuerpo esponjoso. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A Administrar adrenalina intracavernosa

B Propranolol vía oral

C Doxasozina vía oral

D Derivación cavernoesponjosa quirúrgica

E Administrar fenilefrina intracavernosa

Respuesta E. Tiene un priapismo isquémico o verdadero (erección dolorosa y mantenida, limitada a los cuerpos cavernosos). El tratamiento sigue el siguiente orden: 1. Fenilefrina intracavernosa, 2. Procedimientos invasivos (drenaje de los cuerpos cavernosos con suero fisiológico o derivación cavernoesponjosa). Además, se debe buscar la presencia de leucemia y anemia de células falciformes (rara en Chile), aunque en este caso la causa más probable parece estar relacionada con el consumo de cocaína.

▶ VER CLASE **4.03.2.005** **Prostatis aguda** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.13 · Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia

QUÉ HAY QUE SABER

- Prostatitis aguda: fiebre alta con calofríos, disuria, dolor perineal al sentarse y lumbosacro; próstata caliente, tumefacta y muy dolorosa al tacto rectal suave. Agentes: E. coli 75–80% y enterobacterias.
- Diagnóstico: clínica + urocultivo (sin masaje); el masaje prostático está contraindicado por riesgo de bacteriemia y shock. El APE se eleva y debe repetirse tras tratar.
- Ambulatorio: ciprofloxacino 500 mg c/12 h por 3–4 semanas (fluoroquinolonas y cotrimoxazol penetran la próstata; la mayoría de betalactámicos no).
- Con sepsis o intolerancia oral: hospitalizar, ceftriaxona EV ± gentamicina y completar 3–4 semanas.
- Retención urinaria: cistostomía suprapúbica por punción; evitar sonda uretral.
- Seguimiento: derivar si no responde (eco transrectal o TAC para absceso prostático) o en crónicas; categoría crónica bacteriana 6–12 semanas.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 101

Un paciente de 56 años consulta por disminución del calibre miccional, asociado a disuria de esfuerzos de 3 meses de evolución. Hace 7 días se agrega disuria, polaquiuria y malestar. Se solicita APE, que resulta 14,7 ng/ml (valor normal: menor a 4 ng/ml). El tratamiento inicial más adecuado es: **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A Tamsulosina
B Nitrofurantoína
C Ciprofloxacino
D Dutasteride
E Doxazosina

Respuesta C. La clínica de infección urinaria con APE muy elevado sugiere prostatitis aguda. Se trata con ciprofloxacino, y el APE se repite después de tratarla.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 48

Un hombre de 50 años consulta por disuria dolorosa y fiebre, asociada a malestar general, polaquiuria y dolor perineal. Al examen físico presenta fiebre alta, con hemodinamia estable. Se realizan exámenes entre los que destacan sedimento de orina con leucocitos +++, bacterias ++. Su urocultivo está pendiente. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada? **¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?**

A Ciprofloxacino
B Amoxicilina
C Claritromicina
D Nitrofurantoína
E Doxiciclina

Respuesta A. Fiebre, disuria y dolor perineal en un hombre sugieren prostatitis aguda o una infección urinaria febril. El ciprofloxacino cubre ambas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 46 años, fiebre de 39,3 °C con calofríos, dolor lumbosacro, dolor punzante en el periné al sentarse y disuria de 24 horas. Sin globo vesical. Al tacto rectal suave, próstata discretamente aumentada, muy caliente y exquisitamente dolorosa. **¿Cuál es la conducta adecuada?**

A Masaje prostático para obtener secreción
B Urocultivo y ciprofloxacino por 4 semanas
C Nitrofurantoína por 7 días
D Antiinflamatorios y observación
E Biopsia prostática

Respuesta B. Es una prostatitis bacteriana aguda. Se toma urocultivo sin masaje y se inicia una fluoroquinolona de buena penetración prostática por 3 a 4 semanas. El masaje puede causar bacteriemia y shock séptico.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 42 años con 24 horas de fiebre de 39,5 °C, calofríos, dolor perineal que empeora al sentarse y disuria. Al tacto rectal suave, próstata caliente, tumefacta y muy dolorosa. **¿Cuál de las siguientes acciones está formalmente contraindicada?**

A Tomar urocultivo de chorro medio antes de los antibióticos
B Realizar masaje prostático vigoroso para obtener secreción
C Administrar antipiréticos y AINE para el dolor
D Indicar ciprofloxacino oral por 4 semanas
E Realizar cistostomía suprapúbica si hay retención aguda de orina

Respuesta B. En la prostatitis aguda el masaje está contraindicado: comprimir una glándula infectada puede diseminar bacterias a la sangre y causar shock séptico. El diagnóstico se hace con la clínica y el urocultivo.

▶ VER CLASE 4.03.2.006 **Retención urinaria aguda** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.2 · Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Retención urinaria aguda: imposibilidad de orinar con dolor hipogástrico y globo vesical (masa mate suprapúbica); causa más frecuente HPB descompensada por anticolinérgicos, antihistamínicos, opiáceos o alcohol.
- Antes de sondar preguntar por trauma: uretrorragia, hematoma perineal o fractura de pelvis contraindican la sonda (cistostomía y uretrografía retrógrada).
- Sin trauma: sonda Foley 16–18 Fr con lidocaína gel, avanzar sin forzar, inflar el balón con agua bidestilada solo tras ver orina; descompresión continua y completa.
- Si la sonda no pasa o sangra (estenosis, falsa vía) o hay prostatitis aguda: cistostomía suprapúbica por punción.
- Vigilar diuresis postobstructiva si se evacúan >1.000 mL (poliuria, hipovolemia, hipokalemia).
- Después: iniciar tamsulosina (alfabloqueador) y derivar a urología para estudiar la causa; RAO repetida o refractaria es indicación de cirugía de HPB.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 19

Hombre de 70 años con HPB conocida llega a urgencias con incapacidad de orinar desde hace 8 horas, vejiga palpable en hipogastrio y dolor intenso. **¿Cuál es el manejo inicial de elección?**

A Sonda Foley vesical

B Diurético EV

C Alfa-bloqueador oral y esperar

D Cistostomía suprapúbica inmediata

E Cateterismo intermitente

Respuesta A. Retención urinaria aguda: manejo inmediato = sonda Foley para drenaje vesical. Alivia el dolor y previene daño renal. Cistostomía solo si falla la sonda. Alfa-bloqueador se agrega DESPUÉS del episodio agudo para prevención de recurrencia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 5

Un paciente de 68 años consulta por imposibilidad de orinar asociada a dolor abdominal. Refiere que desde hace 3 días presenta dificultades en la micción que progresaron hasta la anuria en las últimas 24 horas. Al examen físico se observa sudoroso, con frecuencia cardíaca de 100 lpm y quejumbroso. El examen abdominal demuestra matidez a la percusión hipogástrica y dolor a la palpación abdominal baja sin signos peritoneales. Tiene antecedente de una resección transuretral hace 10 años por uropatía obstructiva baja asociada a hiperplasia prostática benigna. Se intenta instalar una sonda Foley número 18 por uretra; sin embargo, se encuentra un tope a los 6 cm, con imposibilidad de pasar la sonda y, luego, uretrorragia moderada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Cistostomía abierta

B Intentar instalar una sonda de menor calibre

C UroTAC

D Cistostomía suprapúbica

E Uretrocistografía

Respuesta D. Se trata de una retención urinaria aguda, probablemente por estenosis uretral (post RTU) o recurrencia de hiperplasia prostática. El manejo inicial es sondaje vesical; sin embargo, al fracasar 2 a 3 intentos o al producirse uretrorragia (sugestiva de lesión uretral o falsa vía), la conducta correcta es realizar una cistostomía suprapúbica percutánea para descompresión vesical.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 72 años con dolor intenso en el bajo vientre e imposibilidad de orinar desde hace 14 horas, tras tomar clorfenamina por un resfrío. Está taquicárdico y sudoroso. Se palpa una masa dolorosa y mate en el hipogastrio, 4 cm sobre el pubis. No hay trauma ni sangre en el meato. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Cistostomía suprapúbica por punción

B Sonda Foley transuretral, con descompresión continua

C Sonda Foley con clampeo cada 300 mL

D Solicitar uretrocistografía retrógrada antes de sondar

E Furosemida endovenosa y observar

Respuesta B. Es una retención aguda de orina por un antihistamínico con efecto anticolinérgico, sobre una hiperplasia prostática probable. Sin trauma ni uretrorragia, la primera maniobra es la sonda Foley, con descompresión continua y completa. El clampeo fraccionado no se usa, y se registra el volumen evacuado para vigilar la diuresis postobstructiva.

▶ VER CLASE **4.03.2.007** **Torsión testicular** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.5 · Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h

QUÉ HAY QUE SABER

- Torsión testicular: adolescente (12–18 años) con dolor testicular brusco y desgarrador, a menudo durmiendo, con náuseas y vómitos, sin fiebre ni disuria; anomalía en badajo de campana bilateral.
- Examen: reflejo cremastérico abolido (sensibilidad >95%), testículo ascendido y horizontal (Gouverneur) y Prehn negativo (elevarlo no alivia).
- Viabilidad >90% si se opera antes de 6 horas: ante sospecha alta, exploración quirúrgica inmediata sin esperar imágenes; el eco Doppler solo si la duda es intermedia y no retrasa.
- Destorsión manual (hacia afuera, 'abrir un libro') solo como puente; no reemplaza la cirugía.
- En pabellón: destorsión y orquidopexia; siempre fijar también el testículo contralateral; orquiectomía si no es viable.
- Diferencial: torsión de hidátide (7–12 años, dolor gradual en polo superior, punto azul, cremastérico presente): reposo y AINE. Seguimiento: derivar a urología/cirugía infantil.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 44

Un paciente de 16 años presenta dolor testicular derecho intenso, de inicio súbito, asociado a náuseas. Al examen se palpa el testículo derecho muy doloroso y aumentado de tamaño. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Torsión testicular
B Torsión de la hidátide
C Infarto testicular
D Orquiepididimitis
E Trombosis de varicocele

Respuesta A. Cuadro clásico de torsión testicular. La edad de adolescente orienta más a torsión del cordón que a hidátide, que es de niños más chicos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 158

Un paciente de 16 años, sin antecedentes, consulta por dolor testicular que inició hace una hora, asociado a náuseas, vómitos y sudoración. Al examen físico se aprecia testículo derecho ascendido respecto al contralateral y escaso eritema circundante. **La conducta más adecuada en este caso es:**

A Realizar ecografía testicular
B Indicar doxiciclina y cirpofloxacino
C Indicar ketorolaco endovenoso y suspensión testicular
D Realizar exploración quirúrgica inmediata
E Solicitar exámenes generales, parámetros inflamatorios y sedimento de orina, luego decidir conducta según resultados

Respuesta D. Testículo agudo con sospecha de torsión: exploración quirúrgica inmediata. No se esperan imágenes ni exámenes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 91

Adolescente de 13 años quien consulta por dolor inguinal y testicular izquierdo, intenso, de 45 minutos de evolución, irradiado a hipogastrio y acompañado de náuseas y vómitos. Al examen físico está afebril, con escroto enrojecido, testículo retraído y doloroso a la palpación. **¿Cuál es la conducta a seguir?**

A Administrar AINES
B Administrar antibióticos
C Cirugía
D Realizar suspensión testicular
E Solicitar ecografía testicular

Respuesta C. Es una torsión testicular, o al menos un testículo agudo, y se maneja con exploración quirúrgica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 97

Un paciente de 19 años consulta por dolor en el testículo izquierdo, de inicio brusco y que se ha asociado a vómitos y malestar general. Al examen físico se aprecia testículo izquierdo edematoso, muy doloroso y ascendido. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar exploración quirúrgica escrotal
B Realizar ecografía doppler testicular
C Realizar pieloTAC
D Solicitar TAC de abdomen y pelvis
E Indicar reposo y analgésicos

Respuesta A. Todo testículo agudo se explora, más aún a esta edad, en que se sospecha torsión.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 94

Un hombre de 16 años presenta dolor testicular intenso, que inició hace 8 horas. Tiene EVA 8/10 y al examen testicular se constata testículo derecho muy doloroso, que no mejora con la suspensión testicular. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Antibióticos orales
B Doppler testicular
C Analgésicos orales
D Antibióticos endovenosos
E Exploración quirúrgica

Respuesta E. Dolor testicular intenso en un adolescente que no mejora al elevar el testículo (Prehn negativo): torsión hasta demostrar lo contrario. Se explora. Con 8 horas, el tiempo ya corre en contra.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Adolescente de 14 años llega a las 4 AM por dolor testicular izquierdo brutal de 2 horas, que lo despertó, con dos vómitos. Afebril. El testículo izquierdo está doloroso, ascendido y horizontalizado. El reflejo cremastérico izquierdo está abolido y elevar el testículo no alivia el dolor. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Ecografía Doppler testicular antes de decidir

B Exploración quirúrgica urgente y orquidopexia bilateral

C Ceftriaxona y doxiciclina con control en 24 horas

D Analgésicos, suspensorio escrotal y alta

E Reposo y AINE por torsión de hidátide

Respuesta B. Cuadro típico de torsión del cordón: adolescente, inicio brusco nocturno, vómitos, Gouverneur positivo, Prehn negativo y cremastérico abolido, a solo 2 horas. Se explora de inmediato, sin esperar imágenes, y se fijan ambos testículos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 137

Un paciente de 18 años presenta aumento de volumen escrotal, doloroso, de inicio súbito. La conducta más adecuada es:

A Antibióticos orales

B Punción escrotal

C Antiinflamatorios orales

D Exploración quirúrgica

E Ecografía escrotal

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Exploración quirúrgica (opción D). Puede se runa torsión testicular, por lo que se debe explorar de inmediato. La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

▶ VER CLASE 4.03.2.008 Trauma urológico

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.11 · Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Trauma renal: sospechar con trauma de flanco o desaceleración, equimosis lumbar, fracturas costales bajas o de apófisis transversas y hematuria (macro o microscópica con shock).
- Evaluación ABCDE; el paciente inestable con FAST positivo va a pabellón sin TAC.
- Estable con hematuria: TAC de abdomen y pelvis con contraste y fase excretora (uro-TAC), que clasifica la lesión y muestra extravasación de orina; el pielo-TAC sin contraste no sirve.
- La mayoría de las lesiones renales cerradas se manejan sin cirugía (reposo, hematocrito seriado); angioembolización si hay sangrado activo.
- Trauma vesical/uretral asociado a fractura de pelvis: sangre en el meato, hematoma perineal o próstata alta contraindican la sonda Foley.
- Seguimiento: derivar a urología/cirugía para manejo y control de complicaciones (urinoma, HTA).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 125

Paciente de 35 años sufre un traumatismo lumbar de alta energía y evoluciona con hematuria. Al examen físico está hemodinámicamente estable, con FC 75 lpm y PA 120/80 mmHg. **¿Cuál es el examen de elección para precisar el diagnóstico?**

A PieloTAC

B UroTAC

C Radiografía de abdomen simple

D Ecografía renal

E Pielografía de eliminación

Respuesta B. En el trauma renal con hematuria en un paciente estable, el examen de elección es la TAC con contraste con fase excretora (uroTAC): clasifica la lesión renal, detecta extravasación urinaria y lesiones asociadas. El pieloTAC es sin contraste (para cálculos). La ecografía y la pielografía son poco sensibles. El paciente inestable va a pabellón.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 83

Paciente con trauma en región lumbar + hematuria, examen de elección:

A urotac

B Eco renal y pélvica

C Laparotomía exploratoria

D Cirugía laparoscópica

E Manejo conservador

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (urotac).

▶ VER CLASE **4.03.2.009** **Traumatismo uretral** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.5 · Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz

QUÉ HAY QUE SABER

- Traumatismo uretral: uretra posterior en fractura de pelvis (sínfisis, 'libro abierto'); uretra anterior/bulbar en caída a horcajadas.
- Signos: sangre en el meato (uretrorragia), imposibilidad de orinar con globo vesical, hematoma perineal en alas de mariposa y próstata ascendida o 'flotante' al tacto rectal.
- Contraindicación absoluta: sonda Foley o Nelaton (puede completar la rotura o crear falsa vía).
- Diagnóstico específico: uretrocistografía retrógrada (contraste por el meato) muestra extravasación.
- Manejo inicial: drenaje vesical con cistostomía suprapúbica por punción (idealmente ecoguiada) o abierta; en la pelvis inestable, estabilizar con sábana pélvica y reponer volumen.
- Seguimiento: derivar a urología para reparación uretral diferida y control de estenosis.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 43

Paciente de 46 años sufre un accidente y presenta una fractura de pelvis. Tiene dolor y salida de sangre fresca por la uretra. Además, se palpa la próstata ascendida en el tacto rectal, y no ha podido orinar. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Pedir un TAC de abdomen y pelvis
B Solicitar resonancia magnética
C Realizar cistoscopía
D Instalar sonda Foley
E Instalar una cistostomía

Respuesta E. Uretrorragia y próstata ascendida en un paciente con fractura de pelvis son los signos clásicos de una sección uretral. La sonda Foley está formalmente contraindicada; la conducta es la cistostomía suprapúbica, y luego se estudia con uretrografía retrógrada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 43

Un paciente de 46 años presenta un accidente, resultando con una fractura de pelvis. Presenta dolor y salida de sangre fresca por la uretra. Además se palpa la próstata ascendida en el tacto rectal y no ha podido orinar. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Pedir un TAC de abdomen y pelvis
B Solicitar resonancia magnética
C Realizar cistoscopía
D Instalar sonda Foley
E Instalar cistostomía

Respuesta E. Es una sección uretral. Está contraindicada la sonda Foley y Nelaton. Se instala cistostomía. Se estudia con uretrocistografía retrógrada y no con los exámenes que ahí aparecían. Se resuelve luego con cirugía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 61

Un paciente de 24 años sufre un accidente de tránsito a alta velocidad. Ingresa adolorido, con sangre fresca por uretra. Está en buenas condiciones, con estabilidad hemodinámica y sin signos de fracturas en el examen físico. La tomografía axial computada de tórax abdomen y pelvis muestra fractura de pelvis no desplazada, vejiga distendida, sin líquido libre peritoneal. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A Pielografía de eliminación
B UroTAC
C Uretrocistografía retrógrada
D Ecotomografía pélvica
E Resonancia magnética nuclear de pelvis

Respuesta C. La sospecha es una sección uretral, por lo que se contraindica la sonda Foley, se estudia con uretrocistografía retrógrada, se maneja con cistostomía suprapúbica y, además, con cirugía de reparación uretral.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 90

Un paciente de 42 años sufre un accidente automovilístico, resultado con múltiples traumatismos. Al examen físico tiene movilidad de las extremidades inferiores, sin signos de fractura y examen genital con uretrorragia. Las radiografías confirman una fractura de pelvis estable. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A Pielografía de eliminación endovenosa
B Uretrocistografía retrógrada
C Cistoscopía
D TAC de pelvis
E Resonancia magnética nuclear de pelvis

Respuesta B. Tiene una sección uretral, la que se estudia con uretrocistografía retrógrada y se trata con cirugía. Recordar que está contraindicada la sonda (también la cistoscopía) y, si hay globo vesical, se maneja con cistostomía suprapúbica.

Conocimientos generales

6 códigos

▶ VER CLASE 4.03.3.001

Epidemiología del cáncer de próstata

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.8 · Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer de próstata: es el cáncer más frecuente en hombres en Chile y una de las primeras causas de muerte oncológica masculina; su incidencia aumenta con la edad.
- Factores de riesgo establecidos: edad (excepcional antes de 45–50 años), familiar de primer grado (duplica o triplica el riesgo; BRCA2) y ascendencia africana. No se ha demostrado relación causal con vasectomía.
- Nace en la zona periférica (~75%), por lo que la enfermedad precoz es asintomática; los síntomas urinarios suelen deberse a HPB coexistente.
- Su diagnóstico se basa en APE, tacto rectal y biopsia; está incluido en GES (biopsia en 30 días, tratamiento en 60 días desde la confirmación).
- Gran parte son tumores de bajo riesgo de lenta evolución: de ahí la vigilancia activa y la preocupación por sobrediagnóstico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En una charla de salud del hombre en un CESFAM, se discuten datos epidemiológicos del cáncer de próstata en Chile. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

A Es una neoplasia poco frecuente, principalmente de hombres jóvenes

B Su incidencia es mayor en hombres asiáticos que en afrodescendientes

C El tabaquismo es su principal factor de riesgo

D La vasectomía es un factor de riesgo demostrado

E Es una de las primeras causas de muerte por cáncer en hombres en Chile, y su incidencia aumenta con la edad; la historia familiar y la ascendencia africana son factores de riesgo

Respuesta E. El cáncer de próstata es el más frecuente en hombres en Chile y una de sus principales causas de muerte oncológica. Sus factores de riesgo establecidos son la edad (raro antes de 50 años), la historia familiar de primer grado (y BRCA2) y la ascendencia africana. No se ha demostrado relación causal con vasectomía ni tabaco.

▶ VER CLASE 4.03.3.002

Epidemiología del adenoma de próstata

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.3 · Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP

QUÉ HAY QUE SABER

- Hiperplasia prostática benigna: prevalencia histológica dependiente de la edad, cerca de 50% a los 60 años y 80–90% a los 80 años.
- Requiere andrógenos testiculares (dihidrotestosterona): no ocurre en castrados prepuberales; base del uso de inhibidores de 5-alfa reductasa.
- Nace en la zona de transición (periuretral), no es premaligna y el tamaño se correlaciona mal con los síntomas.
- Es la causa más frecuente de síntomas urinarios bajos y de retención urinaria aguda en el hombre mayor.
- Complicaciones: retención urinaria, ITU, litiasis vesical, hematuria e insuficiencia renal obstructiva; la cirugía de HPB sintomática tiene garantía GES.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En una charla para la comunidad, un médico de un CESFAM explica los aspectos epidemiológicos de la hiperplasia prostática benigna a un grupo de hombres adultos. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

A Es una lesión premaligna que evoluciona a cáncer de próstata en la mayoría de los casos

B Es más frecuente en hombres castrados antes de la pubertad

C Se origina principalmente en la zona periférica de la próstata

D Su prevalencia histológica aumenta con la edad, alcanzando alrededor de 50% a los 60 años y cerca de 80 a 90% a los 80 años, y requiere andrógenos testiculares para desarrollarse

E El tamaño de la próstata se correlaciona estrechamente con la intensidad de los síntomas

Respuesta D. La hiperplasia prostática benigna es muy frecuente y dependiente de la edad y de la dihidrotestosterona: no ocurre en castrados prepuberales. Nace en la zona de transición, no es premaligna, y el tamaño glandular se correlaciona mal con los síntomas. El cáncer, en cambio, nace en la zona periférica.

▶ VER CLASE 4.03.3.003

Epidemiologia del cáncer testicular

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.10 · Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer testicular: tumor sólido más frecuente en hombres de 15 a 35 años (pico 20–35), aunque poco frecuente en términos absolutos.
- Más del 95% son de células germinales: seminoma (50–55%) y no seminoma (embrionario, saco vitelino, coriocarcinoma, teratoma).
- Principal factor de riesgo: criptorquidia (riesgo 4–10 veces; la orquidopexia lo reduce pero no lo elimina); también antecedente personal o familiar y síndrome de Klinefelter.

- Curación >90% incluso con enfermedad avanzada (sensibilidad al cisplatino); garantía GES en personas de 15 años y más.
- Prevención secundaria: examen testicular en controles de adolescentes y adultos jóvenes y orquidopexia precoz de la criptorquidia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En una clase de urología, el docente revisa la epidemiología del cáncer testicular para orientar la sospecha clínica en la atención primaria. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

A Más del 90% corresponde a tumores de estroma gonadal, como el de células de Leydig

B Su incidencia máxima ocurre sobre los 70 años

C Es el tumor sólido más frecuente en hombres de 15 a 35 años, y la criptorquidia es su principal factor de riesgo

D La orquidopexia precoz elimina por completo el riesgo de cáncer en el testículo descendido

E Tiene baja tasa de curación incluso en etapas precoces

Respuesta C. El cáncer testicular es el tumor sólido más frecuente en hombres jóvenes, de 15 a 35 años. Alrededor del 95% son tumores de células germinales. El principal factor de riesgo es la criptorquidia; la orquidopexia reduce pero no elimina el riesgo. Tiene tasas de curación sobre 90% incluso con enfermedad avanzada, y en Chile tiene garantía GES.

▶ VER CLASE 4.03.3.004 Factores de riesgo y prevención de ETS

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.5 · Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH

QUÉ HAY QUE SABER

- Factores de riesgo de ITS: inicio sexual precoz, múltiples parejas o pareja nueva, uso inconsistente de preservativo, sexo bajo efecto de alcohol o drogas, sexo transaccional, HSH e ITS previa.
- Medida más eficaz: uso correcto y consistente del preservativo en todas las relaciones; los anticonceptivos hormonales y el DIU no protegen.
- Vacunación: VPH en el Programa Nacional de Inmunizaciones (escolares, niñas y niños de 4.º y 5.º básico) y hepatitis B en el calendario infantil y grupos de riesgo.
- Exposición de riesgo: profilaxis post exposición (PEP) para VIH lo antes posible y antes de 72 h, por 28 días; PrEP en personas con alto riesgo sostenido.
- Testeo periódico de VIH y sífilis (incluida la embarazada), tratamiento de los contactos de los últimos 60 días y búsqueda de otras ITS ante cualquier diagnóstico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Joven de 19 años consulta para orientación sobre prevención de infecciones de transmisión sexual. Tiene 2 parejas sexuales en el último año y uso inconsistente de preservativo. **¿Cuál es la medida de prevención más efectiva frente a la mayoría de las ITS bacterianas y el VIH en su caso?**

A Vacuna contra VPH, que previene todas las ITS

B Lavado genital después de cada relación

C Uso de anticonceptivos orales

D Uso correcto y consistente del preservativo en todas las relaciones sexuales

E Antibiótico profiláctico mensual

Respuesta D. El preservativo usado de forma correcta y consistente es la medida de barrera más efectiva contra VIH, gonorrea, clamidia y otras ITS. Se complementa con reducción de parejas, tamizaje periódico (VIH, sífilis), vacunas contra VPH y hepatitis B, y PrEP en personas con alto riesgo. Los anticonceptivos orales y el lavado genital no protegen.

▶ VER CLASE 4.03.3.005 Screening de cáncer de próstata

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.8 · Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason

QUÉ HAY QUE SABER

- En Chile no existe un programa de tamizaje poblacional de cáncer de próstata: la detección con APE es oportunista, con decisión informada sobre beneficios y riesgos (sobrediagnóstico, biopsias).
- Población objetivo de la detección: hombres de 50 a 70 años (desde los 45 si hay familiar de primer grado o ascendencia africana); no se tamiza a mayores de 70–75 años ni con expectativa de vida <10 años.
- Se usa APE junto con tacto rectal; corte clásico 4 ng/mL; un APE alterado se repite a las 4–6 semanas descartando ITU, prostatitis o sondeo reciente.
- Con inhibidores de 5-alfa reductasa (finasteride, dutasteride) por más de 6 meses, multiplicar el APE por 2.
- Nódulo pétreo o APE confirmado sobre 4: derivar a urología para biopsia, con garantía GES (30 días desde la sospecha).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 63 años, asintomático, en chequeo de salud. El tacto rectal muestra una próstata algo aumentada con un nódulo indurado, pétreo, de 1 cm en el lóbulo derecho. Trae un APE total de 2,2 ng/mL y se siente aliviado. **¿Cuál es la conducta?**

A Control con APE en 1 año, porque es normal

B Biopsia prostática transrectal ecoguiada

C Antibióticos por 4 semanas por prostatitis

D Solicitar APE libre sobre total para decidir

E Iniciar finasteride y repetir el APE

Respuesta B. Un nódulo pétreo es indicación de biopsia aunque el APE sea normal, porque entre 15 y 25% de los cánceres relevantes tienen APE bajo 4. Se deriva a urología para biopsia con garantía GES.

▶ VER CLASE 4.03.3.006

Trasplante renal, indicaciones y complicaciones

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.1 · Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Trasplante renal: mejor terapia de reemplazo en ERC etapa 5 (mejor sobrevida y calidad de vida que diálisis); está cubierto por GES junto con la diálisis.
- Se evalúa a pacientes en etapa 4–5 sin contraindicación (cáncer activo, infección activa, enfermedad cardiovascular grave no tratable, mala adherencia); donante vivo o cadáver.
- Inmunosupresión habitual: inhibidor de calcineurina (tacrolimus), micofenolato y prednisona; nefrotoxicidad por tacrolimus requiere control de niveles.
- Complicaciones: rechazo (agudo con alza de creatinina, crónico lento), infecciones según tiempo (1–6 meses oportunistas: CMV, Pneumocystis; profilaxis con cotrimoxazol ≥6 meses), pielonefritis del injerto, neoplasias (piel, linfoma) y riesgo cardiovascular.
- El médico general debe reconocer fiebre, dolor sobre el injerto o alza de creatinina y derivar precozmente; revisar interacciones con inhibidores o inductores del CYP3A4.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años, trasplantada renal hace 4 meses, en tratamiento con tacrolimus, micofenolato y prednisona. Consulta por fiebre de 38 °C, tos y disnea progresiva de 1 semana. Radiografía con infiltrado intersticial bilateral. LDH elevada. Suspendió por su cuenta la profilaxis con cotrimoxazol hace 1 mes. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Pneumocystis jirovecii

B Streptococcus pneumoniae

C Mycoplasma pneumoniae

D Legionella pneumophila

E Rechazo agudo del injerto

Respuesta A. Entre el primer y sexto mes postrasplante predominan las infecciones oportunistas (CMV, Pneumocystis), por la inmunosupresión máxima. Neumonía intersticial bilateral con LDH alta e hipoxemia, sin profilaxis con cotrimoxazol, sugiere Pneumocystis jirovecii. Se trata con cotrimoxazol en dosis altas. Por eso la profilaxis se mantiene al menos 6 meses.

Exámenes e imagenología

13 códigos

▶ VER CLASE 4.03.4.001

Radiografía renal y vesical simple

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.1 · Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Radiografía renal y vesical simple (abdomen RUV): ve cálculos radiopacos, que son cerca del 90% (oxalato y fosfato de calcio, estruvita); la cistina es débilmente opaca.
- Los cálculos de ácido úrico son radiolúcidos: no se ven en la radiografía pero sí en el TAC; asociados a gota y orina ácida.
- Indicación principal: seguimiento de la expulsión de un cálculo radiopaco ya visto, con menos radiación que repetir TAC; no es el examen diagnóstico del cólico (es el pielo-TAC).
- Hallazgos a interpretar: calcificaciones en la proyección renal o ureteral, cálculo coraliforme y nefrocalcinosis; diferenciar de flebolitos pélvicos y calcificaciones vasculares.
- Limitaciones: gas intestinal, superposición ósea y poca sensibilidad para cálculos pequeños.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 40 años con cólico renal derecho. La TAC sin contraste muestra un cálculo de 6 mm en el uréter distal derecho, de densidad alta. Se decide manejo médico expulsivo y seguimiento. **¿Cuál es el examen más adecuado para el seguimiento de la expulsión de este cálculo?**

A Radiografía simple renal, ureteral y vesical (de abdomen), ya que la mayoría de los cálculos son radiopacos

B Pielografía de eliminación semanal

C Resonancia magnética de abdomen

D Cintigrama renal

E Cistoscopía

Respuesta A. Cerca del 90% de los cálculos urinarios (oxalato y fosfato de calcio) son radiopacos, por lo que la radiografía simple de abdomen (riñón, uréter y vejiga) sirve para el seguimiento de un cálculo visible, con menor radiación que repetir TAC. Los de ácido úrico son radiolúcidos y no se ven en la radiografía.

▶ VER CLASE 4.03.4.002 Pielografía de eliminación

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.1 · Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Pielografía de eliminación (urografía excretora): radiografías seriadas tras contraste yodado EV; muestra función y anatomía de cálices, pelvis y uréteres.
- Hoy está en gran medida reemplazada por el uro-TAC (para hematuria) y el pielo-TAC (para cólico renal).
- Hallazgos del informe: retardo de eliminación y dilatación en obstrucción, defectos de llenado (tumor urotelial, cálculo radiolúcido, coágulo), duplicidad o malformaciones.
- Contraindicaciones: insuficiencia renal (VFG <30 mL/min, mala imagen y nefropatía por contraste), alergia grave al contraste y embarazo; precaución con metformina.
- Ante un cólico renal no se pide: el examen de elección es el pielo-TAC sin contraste.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Se evalúa a un paciente para un estudio de la vía urinaria con medio de contraste yodado endovenoso (pielografía de eliminación o uroTAC). **¿Cuál de las siguientes condiciones es la principal limitación o contraindicación relativa para este estudio?**

A Hipertensión arterial controlada

B Infección urinaria baja tratada

C Litiasis renal

D Hematuria macroscópica

E Insuficiencia renal con VFG menor de 30 mL/min o antecedente de reacción alérgica grave al medio de contraste

Respuesta E. La pielografía de eliminación (urografía excretora) depende de la excreción renal de contraste yodado, por lo que en insuficiencia renal la imagen es pobre y hay riesgo de nefropatía por contraste; la alergia grave al contraste también la contraindica. Hoy ha sido reemplazada en gran medida por el uroTAC, que comparte estas limitaciones.

▶ VER CLASE 4.03.4.003 Pielo TAC

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.1 · Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Pielo-TAC: TAC de abdomen y pelvis sin contraste; examen de elección en el cólico renal, con sensibilidad y especificidad >95%.
- Ve cálculos de cualquier composición (incluido ácido úrico), su tamaño, ubicación y dureza (UH), la hidronefrosis y diagnósticos diferenciales (apendicitis, diverticulitis, aneurisma).
- El tamaño informado guía la conducta: <5 mm observar, 5–10 mm tamsulosina, >10 mm derivar; ubicación y dureza orientan a LEOC o ureteroscopía.
- No confundir con uro-TAC (con contraste y fase excretora), que se usa para estudiar hematuria y tumores uroteliales.
- En embarazadas y niños se prefiere la ecografía; en el seguimiento de cálculos radiopacos puede bastar la radiografía simple.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 50

Un paciente presenta dolor lumbar intenso irradiado al testículo, asociado a vómitos e inquietud psicomotora. Su sedimento de orina muestra microhematuria. **¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico en este paciente?**

A TAC de abdomen con contraste

B Ecografía abdominal

C PieloTAC

D Pielografía de eliminación

E Radiografía simple de abdomen y pelvis

Respuesta C. Ante un cólico renal típico, el examen de elección es el pieloTAC, una tomografía sin contraste que detecta cálculos de cualquier composición y localización, con sensibilidad y especificidad cercanas a 97%. La ecografía es alternativa en embarazadas y niños, pero ve mal el uréter.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 90

Hombre de 45 años con dolor lumbar derecho irradiado a la región inguinal, tipo cólico, de inicio súbito. Uroanálisis: microhematuria, sin piuria. Urocultivo pendiente. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A Ecografía renal y de vías urinarias
B Resonancia magnética
C UroTAC (PieloTAC sin contraste)
D Radiografía simple de abdomen
E Cintigrafía renal

Respuesta C. Cólico renal (ureterolitiasis): UroTAC sin contraste es el gold standard diagnóstico (sensibilidad 97%, especificidad 96%). Detecta cálculos de cualquier composición, localización y tamaño. La ecografía renal es alternativa inicial (menos sensible para uréteres).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 129

Un paciente de 18 años, sin antecedentes, consulta por dolor en flanco izquierdo de 1 hora de evolución tipo cólico e irradiado a genitales, sin otros síntomas. Su examen físico es normal. Se solicita sedimento de orina muestra 50 eritrocitos por campo, sin dismorfia. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

A Tomografía axial computada con contraste
B Pielografía de eliminación
C Radiografía de abdomen
D Ecografía abdominal
E Tomografía axial computada sin contraste

Respuesta E. Diagnóstico: Tomografía axial computada sin contraste (opción E). El pieloTAC no tiene contraste y es el examen de elección para el cólico renal.

▶ VER CLASE 4.03.4.004 TAC de abdomen y pelvis

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.11 · Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía

QUÉ HAY QUE SABER

- TAC de abdomen y pelvis con contraste: examen de elección para caracterizar masas renales (TAC trifásico: realce >15–20 UH sugiere carcinoma) y quistes complejos (Bosniak).
- Con fase excretora (uro-TAC): estudio de hematuria con riesgo oncológico y del urotelio superior, y del trauma renal en paciente estable (extravasación de orina).
- Otras indicaciones: pielonefritis que no responde a 48–72 h (absceso renal o perirrenal), etapificación de cánceres urológicos y búsqueda de tumor en varicocele derecho o que no colapsa.
- Contraindicaciones relativas: VFG <30 mL/min, alergia al contraste y embarazo; para el cólico renal se usa sin contraste (pielo-TAC).
- El paciente traumatizado inestable no va al TAC: va a pabellón.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 50

Paciente de 30 años sufre una caída de altura, con traumatismo contuso en el flanco derecho, asociado a hematuria macroscópica. Al examen físico presenta equimosis en el flanco derecho, sin otros hallazgos. **¿Cuál de los siguientes exámenes es el más indicado para el estudio de este paciente?**

A Ecografía abdominal
B Tomografía axial computada sin contraste de abdomen
C Radiografía abdominal
D Tomografía axial computada con contraste de abdomen
E Pielografía de eliminación

Respuesta D. Un traumatismo de flanco con hematuria macroscópica en un paciente estable se estudia con TAC de abdomen y pelvis con contraste endovenoso y fase excretora, que clasifica la lesión renal, muestra extravasación de orina y lesiones asociadas. El pieloTAC sin contraste es para la litiasis.

▶ VER CLASE 4.03.4.005 Uretrocistografía

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.2 · Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Uretrocistografía retrógrada: contraste instilado por el meato; examen de elección ante sospecha de trauma uretral (sangre en el meato, fractura de pelvis, caída a horcajadas) y para estenosis de uretra anterior.
- Hallazgos: extravasación de contraste (rotura uretral) o estrechez con su ubicación y longitud (estenosis).
- Uretrocistografía miccional: se llena la vejiga y se obtienen imágenes al orinar; diagnostica y gradúa el reflujo vesicoureteral (I a V) y las valvas uretrales posteriores (uretra posterior dilatada).
- La miccional se pide en niños con ecografía alterada o ITU febril atípica o recurrente, fuera de la fase aguda y con urocultivo negativo.
- Ante sospecha de lesión uretral no se sonda antes del estudio; si hay globo vesical se drena con cistostomía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 142

Paciente con antecedente de resección transuretral de próstata hace 10 años, sin micción desde hace 8 horas. Al intentar instalar una sonda, esta no avanza más allá de la uretra bulbar y se produce uretrorragia. No hay globo vesical palpable. **¿Cuál es el examen de elección?**

A Ecografía pelviana

B UroTAC sin contraste

C Uretrografía retrógrada

D Cistouretrografía miccional

E Cistoscopía flexible

Respuesta C. Una sonda que no progresa en la uretra bulbar en un paciente con instrumentación previa sugiere estenosis uretral. La uretrografía retrógrada (contraste por el meato) define ubicación y longitud de la estenosis anterior. La cistouretrografía miccional requiere que el paciente orine o vejiga accesible, y evalúa mejor la uretra posterior y el reflujo.

▶ VER CLASE 4.03.4.006 Ecografía renal (tamaño, asimetrías, hidronefrosis)

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 1.1 · Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca

QUÉ HAY QUE SABER

- Ecografía renal: examen inicial, inocuo y sin contraste para evaluar tamaño renal, asimetrías, hidronefrosis, quistes, masas y litiasis.
- Ante injuria renal aguda, el primer paso es descartar obstrucción: hidronefrosis bilateral o globo vesical indica causa postrenal tratable.
- Riñones pequeños (<9 cm), con corteza adelgazada e hiperecogénicos indican ERC avanzada; excepciones con riñones grandes: diabetes, poliquistosis, amiloidosis y VIH.
- Asimetría >1,5 cm sugiere enfermedad renovascular; riñones grandes con múltiples quistes bilaterales, poliquistosis.
- Quiste simple (anecogénico, pared fina, refuerzo posterior): alta; quiste complejo o masa sólida: TAC con contraste. En niños, a todos tras la primera ITU febril.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 75 años con creatinina de 3,2 mg/dL (basal desconocida), sin síntomas urinarios claros. Se solicita ecografía renal. **¿Qué hallazgo ecográfico orienta más a enfermedad renal crónica que a injuria renal aguda?**

A Riñones de tamaño normal con hidronefrosis bilateral

B Riñones aumentados de tamaño

C Riñones pequeños (menores de 9 cm), con corteza adelgazada y aumento de la ecogenicidad

D Asimetría renal mayor de 1,5 cm por uno grande

E Vejiga distendida

Respuesta C. La ecografía renal permite distinguir cronicidad: riñones pequeños, de corteza delgada e hiperecogénicos indican ERC avanzada. Además descarta obstrucción (hidronefrosis), la principal causa reversible, y detecta asimetrías (mayor de 1,5 cm sugiere enfermedad renovascular). Excepciones de ERC con riñones grandes: diabetes, poliquistosis, amiloidosis y VIH.

▶ VER CLASE 4.03.4.007 Ecotomografía de vejiga y próstata

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.3 · Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP

QUÉ HAY QUE SABER

- Ecotomografía vésico-prostática (suprapúbica): estima el volumen prostático y mide el residuo postmiccional; residuo >100–150 mL indica vaciamiento incompleto y riesgo de retención.
- Muestra repercusión vesical de la obstrucción: vejiga de lucha (pared engrosada, trabeculada), divertículos y litiasis vesical; complementar con ecografía renal para hidronefrosis.
- El volumen orienta el tratamiento de la HPB: >40 cc agregar inhibidor de 5-alfa reductasa; <80 cc RTUP, >80 cc adenomectomía o láser.
- No diagnostica cáncer de próstata (requiere APE, tacto y biopsia transrectal ecoguiada), ni mide flujo ni presiones.
- Útil también en incontinencia (residuo >200 mL confirma rebalse) y en masas vesicales.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años con síntomas urinarios bajos obstructivos moderados (IPSS 18), tacto rectal con próstata aumentada de tamaño, lisa, elástica y sin nódulos. Creatinina normal. **¿Qué información principal aporta la ecotomografía vesical y prostática en este paciente?**

A Diagnóstico histológico de cáncer de próstata

B Volumen prostático, residuo postmiccional y repercusión vesical (engrosamiento de pared, divertículos, cálculos)

C Medición del flujo urinario máximo

D Presión del detrusor durante la micción

E Etapificación ganglionar

Respuesta B. En la HPB, la ecografía vesicoprostática (suprapúbica) mide el volumen prostático, el residuo postmiccional y muestra repercusión vesical (vejiga de lucha, divertículos, litiasis); la ecografía renal descarta hidronefrosis. No diagnostica cáncer (requiere APE y biopsia) ni mide flujo (uroflujometría) ni presiones (urodinamia).

▶ VER CLASE 4.03.4.008 Ecotomografía testicular

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA

Urología 13.5 · Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h
Urología 13.10 · Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical

QUÉ HAY QUE SABER

- Ecografía testicular con Doppler: primer examen ante toda masa escrotal; distingue lesión intratesticular sólida (sospechosa de cáncer, sensibilidad cercana al 100%) de lesiones extratesticulares benignas.
- Tumor: nódulo intratesticular hipoecogénico, heterogéneo y con flujo aumentado; se complementa con AFP, beta-hCG y LDH y se deriva para orquiectomía inguinal.
- Escroto agudo: ausencia de flujo intratesticular y signo del remolino sugieren torsión; flujo aumentado en epidídimo, epididimitis; nódulo avascular en polo superior con flujo conservado, torsión de hidátide.
- En la torsión con sospecha clínica alta no se espera la ecografía: exploración quirúrgica inmediata.
- Otros hallazgos: hidrocele (líquido que rodea el testículo, obligatorio descartar tumor en adulto), quiste de epidídimo y varicocele (venas >3 mm con reflujo en Valsalva).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Escolar de 11 años consulta por dolor testicular derecho de 20 horas, de inicio gradual, moderado, sin vómitos. Afebril. El testículo derecho está en posición normal, levemente sensible en su polo superior, con reflejo cremastérico presente. El cuadro es dudoso, por lo que se solicita ecografía Doppler testicular inmediata. **Si la ecografía Doppler muestra flujo arterial intratesticular conservado y simétrico, con una imagen nodular avascular en el polo superior, ¿cuál es la interpretación y conducta más adecuada?**

A Torsión testicular; exploración quirúrgica inmediata

B Hidrocele a tensión; punción evacuadora

C Tumor testicular; orquiectomía inguinal

D Orquiepididimitis bacteriana; ceftriaxona más doxiciclina

E Torsión de hidátide (apéndice testicular); reposo, AINE, frío local y control

Respuesta E. La ecografía Doppler testicular es útil cuando el escroto agudo es dudoso: flujo intratesticular conservado descarta razonablemente la torsión, y un nódulo avascular en el polo superior es típico de la torsión de hidátide, que se trata en forma conservadora. Si la clínica es clara de torsión, no se debe retrasar la cirugía por la ecografía.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 28 años nota hace 3 semanas un nódulo en el testículo izquierdo, levemente molesto. Al examen se palpa un nódulo duro de 1,5 cm que parece depender del testículo, no transilumina, sin signos inflamatorios. Afebril y sin síntomas urinarios. **¿Cuál es el examen inicial más adecuado?**

A Biopsia testicular por punción transescrotal

B Ecografía testicular con Doppler

C TAC de tórax, abdomen y pelvis

D Tratamiento antibiótico por 2 semanas y luego reevaluar

E Resonancia magnética de pelvis

Respuesta B. Ante toda masa escrotal, el examen inicial es la ecografía testicular: distingue lesión intratesticular sólida, sospechosa de cáncer, de lesiones extratesticulares benignas como quistes del epidídimo o hidrocele, con sensibilidad cercana a 100%. La punción transescrotal está contraindicada por riesgo de diseminación.

▶ VER CLASE 4.03.4.009 Cintigrama renal

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA

Pediatría 18.13 · Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Cintigrama renal estático con DMSA: examen de elección para detectar cicatrices renales (daño parenquimatoso) tras pielonefritis, realizado 4–6 meses después del episodio.

- En la fase aguda puede mostrar defectos inflamatorios reversibles que no son cicatriz; por eso se difiere.
- También informa la función renal diferencial (cada riñón aporta normalmente 45–55%).
- Cintigrama dinámico (MAG3 o DTPA con diurético): evalúa obstrucción (curva de eliminación) y función diferencial en hidronefrosis y estenosis pieloureteral; función ≤10% sugiere riñón no recuperable.
- No evalúa reflujo: para eso se usa la uretrocistografía miccional.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niña de 2 años que tuvo una pielonefritis aguda febril hace 5 meses, tratada adecuadamente. Su ecografía renal fue normal. Se desea evaluar si quedaron cicatrices en el parénquima renal. **¿Cuál es el examen de elección?**

A TAC de abdomen sin contraste

B Cintigrama renal con MAG3 y diurético

C Uretrocistografía miccional

D Urocultivo de control

E Cintigrama renal con DMSA (ácido dimercaptosuccínico)

Respuesta E. El cintigrama estático con DMSA es el estándar para detectar cicatrices renales; se realiza 4 a 6 meses después de la pielonefritis para no confundir inflamación aguda con cicatriz. El cintigrama dinámico (MAG3 o DTPA con diurético) evalúa obstrucción y función diferencial con curva de eliminación. La uretrocistografía evalúa reflujo, no cicatrices.

▶ VER CLASE 4.03.4.010 Antígeno prostático específico

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.8 · Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason

QUÉ HAY QUE SABER

- Antígeno prostático específico (APE): proteasa órgano-específica, no cáncer-específica; sube en cáncer, HPB, prostatitis, ITU, sondeo, biopsia y eyaculación reciente.
- Corte clásico 4 ng/mL; >10 alto riesgo. Un valor alterado se repite a las 4–6 semanas tras descartar o tratar infección.
- Afinan la zona gris (4–10): relación libre/total <15% sugiere cáncer; densidad >0,15 y velocidad >0,75 ng/mL/año también.
- Finasteride o dutasteride por >6 meses lo reducen a la mitad: multiplicar por 2; la tamsulosina no lo modifica.
- Un APE normal no descarta cáncer: un nódulo pétreo al tacto obliga a biopsia; tras tratamiento se usa para detectar recidiva.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 61 años, asintomático. Tacto rectal normal. APE total de 6,2 ng/mL; descartada una infección urinaria, se repite a las 4 semanas: 6,4 ng/mL, con relación APE libre/total de 9%. **¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?**

A Tamsulosina y control con APE en 1 año

B Biopsia prostática guiada por ecografía transrectal

C Cintigrama óseo de entrada

D Finasteride por 6 meses para ver si el APE baja

E Tranquilizar porque no hay nódulo

Respuesta B. APE confirmado en la zona gris con fracción libre de 9%, menor de 15%: alto riesgo de cáncer. Corresponde biopsia. El finasteride enmascararía el APE y retrasaría el diagnóstico.

▶ VER CLASE 4.03.4.011 Examen de orina completo, urocultivo

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.15 · Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Orina completa: hematuria ≥3 GR/campo; GR dismórficos, acantocitos y cilindros hemáticos indican origen glomerular; coágulos indican origen urológico. Cilindros leucocitarios: origen renal (pielonefritis, nefritis intersticial).
- Nitritos positivos son específicos de enterobacterias, pero un nitrito negativo no descarta ITU (requiere ~4 h de orina en vejiga; Enterococcus y S. saprophyticus no los producen).
- Urocultivo: segundo chorro ≥100.000 UFC/mL; en mujer con cistitis y piuria, desde 1.000–10.000 UFC/mL de un uropatógeno es significativo. Niños: cateterismo ≥10.000, punción suprapúbica cualquier recuento; bolsa recolectora solo sirve si es negativa.
- Piuria estéril (leucocituria con urocultivo negativo): pensar en TBC urinaria, uretritis por Chlamydia, nefritis intersticial o tratamiento antibiótico previo.
- Bacteriuria asintomática no se trata salvo en embarazo o antes de cirugía urológica con sangrado de mucosa; tomar siempre urocultivo antes de antibiótico en pielonefritis.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 28 años, no embarazada, consulta por disuria, polaquiuria y urgencia miccional de 2 días, sin fiebre ni dolor lumbar. Se toma orina de segundo chorro con aseo genital previo. Orina completa: nitritos positivos, leucocitos 25 a 30 por campo, bacterias abundantes. El urocultivo informa Escherichia coli 10.000 UFC/mL sensible a nitrofurantoína. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Urocultivo negativo porque no alcanza 100.000 UFC/mL; no corresponde tratar

B Contaminación de la muestra; repetir con punción suprapúbica

C Infección urinaria baja; en una mujer sintomática con piuria, un recuento desde 1.000 a 10.000 UFC/mL de un uropatógeno es significativo y se trata, por ejemplo con nitrofurantoína

D Bacteriuria asintomática; no requiere tratamiento

E Pielonefritis aguda; hospitalizar para antibióticos endovenosos

Respuesta C. El punto de corte de 100.000 UFC/mL se diseñó para bacteriuria asintomática. En una mujer con síntomas de cistitis y piuria, recuentos menores (desde 1.000 a 10.000 UFC/mL) de un uropatógeno como E. coli son significativos. Los nitritos positivos y la piuria apoyan el diagnóstico de cistitis, que se trata ambulatoriamente.

▶ VER CLASE 4.03.4.012 Urodinamia

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.4 · Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica

QUÉ HAY QUE SABER

- Urodinamia (cistometría y estudio flujo-presión): mide presiones vesical y abdominal durante el llenado y el vaciamiento.
- Indicaciones: incontinencia mixta o refractaria, antes de cirugía antiincontinencia, vejiga neurogénica, síntomas que no calzan con la clínica o falla de tratamiento.
- Distingue hiperactividad del detrusor (contracciones involuntarias en el llenado) de incompetencia esfinteriana, y obstrucción infravesical de hipocontractilidad del detrusor.
- No es necesaria en la incontinencia de esfuerzo pura no complicada antes del tratamiento conservador.
- Su informe evita cirugías que empeoren la urgencia o provoquen retención.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 55 años con incontinencia urinaria mixta (esfuerzo y urgencia) que no mejoró con ejercicios de piso pélvico ni con antimuscarínicos. Se plantea cirugía antiincontinencia. **¿Cuál es la principal utilidad del estudio urodinámico en esta paciente?**

A Confirmar infección urinaria

B Objetivar el tipo de incontinencia (hiperactividad del detrusor vs incompetencia esfinteriana) y la función de vaciamiento antes de la cirugía

C Medir el volumen de la vejiga en reposo por ecografía

D Diagnosticar cáncer vesical

E Reemplazar el examen físico ginecológico

Respuesta B. La urodinamia (cistometría, estudio de flujo-presión) mide presiones vesicales y abdominales durante llenado y vaciamiento. No es necesaria en la incontinencia de esfuerzo pura no complicada, pero sí en la incontinencia mixta, refractaria o antes de cirugía, para documentar hiperactividad del detrusor o incompetencia esfinteriana y evitar cirugías que empeoren la urgencia o produzcan retención.

▶ VER CLASE 4.03.4.013 Uroflujometría

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.3 · Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP

QUÉ HAY QUE SABER

- Uroflujometría: mide el flujo urinario durante una micción espontánea; válida con volumen miccional >150 mL.
- Normal: Qmáx >15 mL/s con curva en campana; Qmáx <10 mL/s con curva aplanada y prolongada sugiere obstrucción (HPB, estenosis uretral) o hipocontractilidad del detrusor.
- Curva en meseta (plateau) es típica de estenosis uretral; para diferenciar obstrucción de detrusor débil se requiere estudio flujo-presión.
- Se complementa con residuo postmiccional por ecografía.
- Usos: evaluación inicial y seguimiento de síntomas urinarios bajos en el hombre, control post RTUP o uretrotomía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 65 años con chorro débil y sensación de vaciamiento incompleto. Se realiza uroflujometría con volumen miccional de 250 mL. **¿Qué resultado sugiere obstrucción del tracto urinario inferior?**

A Flujo máximo (Qmáx) mayor de 15 mL/s con curva en campana

B Volumen miccional de 250 mL

C Flujo máximo menor de 10 mL/s con curva aplanada y prolongada

D Residuo postmiccional de 10 mL

E Tiempo miccional de 15 segundos

Respuesta C. La uroflujometría mide el flujo urinario; es válida con volumen miccional mayor de 150 mL. Un Qmáx menor de 10 mL/s con curva aplanada y prolongada sugiere obstrucción (HPB, estenosis uretral) o hipocontractilidad del detrusor; mayor de 15 mL/s es normal. Para diferenciarlas se requiere estudio de flujo-presión.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

6 códigos

▶ VER CLASE 4.03.5.001 **Biopsia prostática** NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.8 · Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason

QUÉ HAY QUE SABER

- Biopsia prostática: transrectal (o transperineal) guiada por ecografía, idealmente con fusión con resonancia; 10–12 cilindros; único método que confirma el cáncer de próstata.
- Indicaciones: nódulo pétreo o asimetría al tacto rectal (aunque el APE sea normal) o APE >4 ng/mL confirmado, con relación libre/total baja o RM sospechosa.
- El médico general deriva a urología con garantía GES: biopsia dentro de 30 días desde la sospecha fundada.
- Requiere profilaxis antibiótica (transrectal) y suspender anticoagulantes/antiagregantes según indicación; complicaciones: hematuria, hemospermia, rectorragia, retención y prostatitis/sepsis.
- Resultado: Gleason/ISUP (3+3 ISUP 1 bajo riesgo; 4+3 ISUP 3 peor que 3+4) que define riesgo y tratamiento.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 78

Un paciente de 60 años, que durante una infección urinaria, se detectó APE de 14,2 ng/ml y un tacto rectal, con presencia de un nódulo prostático duro. Una vez tratada con éxito su infección, el APE bajó a 12 ng/ml. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Prostatectomía radical

B Seguimiento con APE y tacto en 1 año

C Ecografía de próstata

D Resección transuretral

E Biopsia prostática

Respuesta E. Tanto por el nódulo como por el APE mayor a 4, está indicada la biopsia.

▶ VER CLASE 4.03.5.002 **Cistoscopia** NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.12 · Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV

QUÉ HAY QUE SABER

- Cistoscopía: visualización endoscópica directa de uretra y vejiga; examen que confirma el cáncer vesical y permite biopsia.
- Indicación principal: hematuria macroscópica o microscópica urológica en paciente con riesgo (>50 años, fumador, aminas aromáticas), junto con uro-TAC; la citología no la reemplaza.
- Otras: síntomas irritativos refractarios (carcinoma in situ), seguimiento de cáncer vesical, instalación de catéter doble J, estudio de estenosis y fístulas.
- Contraindicada en sospecha de trauma uretral y relativamente en ITU activa (tomar urocultivo antes).
- El médico general deriva a urología; no reemplaza el estudio de la vía urinaria superior.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 45

Un paciente de 68 años, fumador de 20 paquetes-año, presenta hematuria abundante, con coágulos. Se realiza un sedimento que muestra incontables glóbulos rojos y un urocultivo que resulta negativo. Se le realiza un TAC de abdomen y pelvis que no muestra alteraciones. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir con el estudio en este paciente? **¿Qué examen es el más adecuado para proseguir el estudio?**

A Ecografía pélvica
B Resonancia magnética nuclear
C Pielografía de eliminación
D Cistoscopía
E Uretrocistografía

Respuesta D. Probable cáncer de vejiga. El TAC ya descartó causa renal, y falta ver la mucosa de la vejiga con cistoscopía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 85

Una paciente de 54 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de disuria, polaquiuria y dolor abdominal bajo. Sus urocultivos repetidos han resultado negativos. Al examen físico tiene mucosa vaginal seca y pálida. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Iniciar terapia de reemplazo hormonal oral
B Solicitar cistoscopía
C Solicitar ecografía transvaginal
D Indicar estrógenos tópicos
E Iniciar antimicóticos orales

Respuesta B. Es una pregunta discutible, ya que tiene la historia de una cistitis intersticial (se estudia con cistoscopía) y también la de atrofia genital (se trataría con estrógenos tópicos). El dolor abdominal bajo y la polaquiuria sugieren mucho más una cistitis intersticial.

▶ VER CLASE **4.03.5.003** **Cistostomía abierta**

NIVEL **DERIVAR A ESPECIALISTA**

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.2 · Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Cistostomía abierta (quirúrgica): drenaje vesical suprapúbico mediante incisión, en pabellón.
- Indicaciones: drenaje vesical cuando la cistostomía por punción no es segura o es imposible (vejiga no palpable o no distendida, cirugía pélvica previa, obesidad, coagulopatía) o en trauma uretral que requiere exploración vesical.
- En trauma uretral con globo vesical palpable, la opción inicial es la punción (ecoguiada); la abierta se reserva a los casos anteriores.
- El médico general estabiliza, no sonda la uretra con sospecha de lesión y deriva a urología/cirugía.
- Cuidados posteriores: fijación del catéter, cambios periódicos y vigilancia de infección del trayecto.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años, tras caída a horcajadas sobre una viga, presenta sangre en el meato uretral, hematoma perineal en alas de mariposa y no puede orinar. Tiene globo vesical palpable. Está estable. **¿Cuál es la conducta más adecuada para drenar la vejiga?**

A Instalar sonda Foley por vía uretral con fuerza
B Sondeo con sonda metálica
C Esperar micción espontánea
D Cistostomía suprapúbica (por punción o abierta) y luego estudio con uretrografía retrógrada
E Uretroplastía inmediata

Respuesta D. Uretrorragia, hematoma perineal y retención tras trauma a horcajadas indican lesión de uretra bulbar. Está contraindicado el sondeo uretral a ciegas porque puede completar la rotura. La vejiga se drena con cistostomía suprapúbica (percutánea o abierta si la vejiga no es puncionable con seguridad), y se estudia con uretrografía retrógrada; la reparación es diferida.

▶ VER CLASE **4.03.5.004** **Cistostomía por punción**

NIVEL **REALIZAR**

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.2 · Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Cistostomía por punción (Cystofix): drenaje vesical suprapúbico percutáneo con trocar de 10–14 Fr, idealmente guiado por ecografía.
- Indicaciones: retención urinaria con trauma uretral (uretrorragia, hematoma perineal, fractura de pelvis), sonda Foley imposible (estenosis, falsa vía) y prostatitis aguda.
- Requisito: globo vesical palpable o vejiga distendida confirmada; contraindicada sin globo, con cirugía o cáncer vesical/pélvico, coagulopatía o infección de la pared.
- Técnica: punción en línea media 2 traveses de dedo sobre el pubis, perpendicular o levemente caudal, aséptica con anestesia local; confirmar orina y fijar.
- Complicaciones: punción intestinal, hematoma de pared y hematuria; luego estudiar la uretra con uretrografía retrógrada y derivar a urología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 25 años sufre una caída a horcajadas sobre una viga. Consulta por imposibilidad de orinar de 6 horas. Al examen hay sangre en el meato uretral, hematoma perineal en alas de mariposa y globo vesical palpable a 3 cm bajo el ombligo. Hemodinámicamente estable. **¿Cuál es la conducta más adecuada para drenar la vejiga?**

A Sonda Foley transuretral con lubricación abundante

B Punción vesical con aguja y aspiración repetida cada 6 horas

C Sondeo con sonda metálica para vencer la estrechez

D Furosemida endovenosa y esperar micción espontánea

E Cistostomía suprapúbica por punción, idealmente guiada por ecografía, y estudio posterior con uretrografía retrógrada

Respuesta E. Sangre en el meato y hematoma perineal tras caída a horcajadas sugieren lesión de uretra bulbar: está contraindicado el sondeo transuretral. Con globo vesical palpable, la vejiga se drena mediante cistostomía suprapúbica por punción, y la uretra se estudia con uretrografía retrógrada.

▶ VER CLASE 4.03.5.005 Instalación y cuidado de sonda Foley

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.2 · Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones de sonda Foley: retención urinaria sin trauma, medición de diuresis horaria en paciente crítico, cirugía prolongada, hematuria con coágulos (sonda 3 vías 20–24 Fr). Contraindicada si hay sospecha de lesión uretral.
- Técnica: aséptica; en el hombre lubricar con lidocaína gel 2%, calibre 16–18 Fr, avanzar sin forzar hasta la bifurcación y solo tras ver salir orina inflar el balón con agua destilada (10 mL).
- Inflar el balón en la uretra causa dolor, sangrado y falsa vía; ante resistencia o sangre en el meato no forzar (cistostomía).
- Cuidados: sistema cerrado, bolsa bajo el nivel vesical, reponer el prepucio (evitar parafimosis) y retirar apenas no se necesite; no indicar profilaxis antibiótica ni tratar la bacteriuria asintomática.
- Retención crónica con >1.000 mL evacuados: descompresión continua y vigilar diuresis postobstructiva y potasio.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 70 años hospitalizado por neumonía requiere sonda Foley para medir diuresis horaria. Al instalarla, después de introducir unos 10 cm, aún no sale orina. **Respecto de la técnica y cuidados de la sonda Foley, ¿cuál afirmación es correcta?**

A Inflar el balón en cuanto se sienta resistencia, para fijarla

B Mantener la bolsa sobre el nivel de la vejiga para facilitar el drenaje

C Cambiar la bolsa abriendo el sistema cada 8 horas para evitar infecciones

D Introducir la sonda hasta la bifurcación y verificar la salida de orina antes de inflar el balón con agua destilada, con técnica aséptica y sistema de drenaje cerrado

E Indicar profilaxis antibiótica permanente mientras dure la sonda

Respuesta D. En el hombre se lubrica con lidocaína en gel, se introduce la sonda hasta la bifurcación y solo después de ver orina se infla el balón, para no inflarlo en la uretra. Se usa técnica aséptica, sistema cerrado, bolsa bajo el nivel vesical y se retira apenas no se necesite. La profilaxis antibiótica no está indicada.

▶ VER CLASE 4.03.5.006 Reducción de parafimosis

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.16 · Patología Peneana: Fimosis, Parafimosis, Balanopostitis, Priapismo & Disfunción Eréctil

QUÉ HAY QUE SABER

- Parafimosis: prepucio retraído que forma anillo constrictor detrás del glande, con edema; urgencia por riesgo de isquemia.
- Preparación: analgesia (bloqueo peneano dorsal o anestesia tópica) y explicar el procedimiento.
- Técnica: compresión manual sostenida del glande por varios minutos para reducir el edema; luego empujar el glande con ambos pulgares mientras los dedos índice y medio traccionan el anillo prepucial hacia distal.
- No aplicar calor; si la reducción fracasa o hay necrosis, derivar para incisión dorsal del anillo.
- Tras la reducción: control del edema y derivar para circuncisión electiva.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 10 años con parafimosis de 3 horas tras retraer el prepucio al bañarse. Glande edematoso, rosado, con anillo constrictor retraído. Se decide reducción manual en urgencia. **¿Cuál es la técnica adecuada?**

A Tirar del prepucio hacia adelante sin preparar el glande

B Analgesia, compresión manual sostenida del glande para reducir el edema, y luego empujar el glande con los pulgares mientras los índices y medios traccionan el prepucio hacia distal

C Incisión dorsal del prepucio como primera medida

D Aplicar calor local y esperar reducción espontánea

E Indicar corticoide tópico y control en 1 semana

Respuesta B. La reducción manual de la parafimosis requiere analgesia (bloqueo peneano o anestesia tópica), compresión sostenida del glande para disminuir el edema y luego presión del glande con los pulgares mientras los dedos índice y medio llevan el anillo prepucial sobre él. Si falla, se realiza incisión dorsal. El calor aumenta el edema.

15 PSIQUIATRÍA

60 CÓDIGOS

229 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	36
Situaciones clínicas de urgencia	3
Conocimientos generales	13
Exámenes e imagenología	4
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	4

Situaciones clínicas

36 códigos

▶ VER CLASE **5.01.1.001** **Trastorno de pánico con o sin agorafobia** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.6 · Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS

QUÉ HAY QUE SABER

- Crisis de pánico: inicio brusco con pico en <10 minutos y ≥4 de 13 síntomas (palpitaciones, disnea, dolor torácico, sudor, temblor, parestesias, mareo, desrealización, miedo a morir o perder el control).
- Trastorno de pánico: crisis recurrentes e imprevistas más ≥1 mes de miedo a nuevas crisis o cambio de conducta; agorafobia (miedo a no poder escapar en ≥2 situaciones) es su complicación frecuente.
- Primer episodio: descartar lo somático con ECG, glicemia capilar, saturación y TSH (y troponinas o tóxicos según clínica): SCA, TEP, arritmias, hipertiroidismo, feocromocitoma, cocaína.
- Crisis aguda: contención verbal y respiración diafragmática lenta; si no cede, lorazepam 1–2 mg sublingual (o clonazepam 0,5–1 mg). No respirar en bolsa.
- Tratamiento de fondo: ISRS partiendo con media dosis (sertralina 25 mg por 7 días y luego 50 mg; o escitalopram) más TCC con exposición; benzodiacepina solo como puente 2–4 semanas con retiro gradual.
- Seguimiento completo: controles para titular, vigilar ansiedad inicial por ISRS y mantener el tratamiento 6–12 meses tras la remisión; evitar benzodiacepina en monoterapia crónica.

PREGUNTAS · 18

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 66

Una paciente presenta múltiples episodios de 5 minutos de duración, recurrentes, en los que presenta mucha angustia, llanto, sensación de ahogo, parestesias en las cuatro extremidades y marcado miedo a sufrir un infarto al corazón. Ya no sale de la casa por miedo a presentar uno de esos episodios en la calle. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A Trastorno de pánico
B Agorafobia
C Trastorno de angustia generalizada
D Trastorno de ansiedad social
E Crisis de pánico

Respuesta A. Crisis de pánico recurrentes e inexplicadas: trastorno de pánico. Que ya no salga de su casa sugiere además agorafobia, pero predomina el diagnóstico de trastorno de pánico. "Crisis de pánico" es solo el episodio, no el trastorno.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 113

Una paciente de 36 años, sin antecedentes, consulta porque desde hace tres meses ha presentado varios episodios caracterizados por taquicardia, sudoración, dificultad para respirar, náuseas y sensación de muerte que tienen una duración de 30 minutos máximo y que ceden espontáneamente, por lo cual está muy preocupada, ya que dos de ellos le ocurrieron cuando se encontraba en una cafetería. Refiere que hace tres meses su pareja le pidió el divorcio en un restaurant, tras lo cual, intenta no salir de su hogar por miedo a que algo le ocurra y nadie la ayude. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A Trastorno por ansiedad social
B Trastorno adaptativo
C Trastorno por estrés post traumático
D Agorafobia
E Trastorno de ansiedad

Respuesta E. Tiene un trastorno de pánico (ansiedad o angustia) con agorafobia. Se prefiere el diagnóstico de trastorno de pánico por ser más completo; la agorafobia es en este caso una consecuencia, y el pánico se clasifica con o sin agorafobia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 67

Una paciente de 24 años, sin antecedentes, consulta en urgencias por cuadro de inicio brusco caracterizado por sensación de falta de aire, dolor en hemitórax izquierdo, mareos, sudoración y adormecimiento de manos, de 30 minutos de duración. Al examen físico presenta frecuencia cardiaca 120 por minuto, presión arterial 140/90, cardiopulmonar normal. Se solicita electrocardiograma que muestra ritmo sinusal, QRS angosto, sin signos de isquemia. El fármaco de elección para el manejo en este caso es: **El fármaco de elección para el manejo en este caso es:**

A Haloperidol
B Diazepam
C Lorazepam
D Fenitoína
E Clonazepam

Respuesta C. Crisis de pánico con electrocardiograma normal. El fármaco de rescate de elección es lorazepam sublingual, de vida media más corta que diazepam y clonazepam.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 12

Una paciente de 28 años presenta un episodio de rápida instalación de marcada angustia y variados síntomas como disnea con "imposibilidad de sacar el aire", vértigo, parestesias en las extremidades, imposibilidad de tragar, opresión en el pecho, náuseas, visión borrosa y miedo a morir. En las últimas 4 semanas ha presentado varios episodios similares, por lo que teme salir de su casa. Su examen físico es normal y los exámenes generales descartan patología orgánica. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente? **¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?**

A Amitriptilina 25 mg/día

B Sertralina 50 mg/día

C Risperidona 3 mg/día

D Clonazepam 2 mg/día

E Clorpromazina 300 mg/día

Respuesta B. Crisis de pánico recurrentes: trastorno de pánico, probablemente con agorafobia. El tratamiento principal es un ISRS. Las benzodiacepinas sirven como tratamiento sintomático, pero el ISRS es la base.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 103

Una paciente de 31 años, embarazada de 3 meses, presenta angustia y temor, que aparece al estar en presencia de aglomeraciones de personas, especialmente en la calle, sintiéndose atrapada y ahogada en esas situaciones. Refiere síntomas similares al ir al supermercado y al tener que cruzar puentes muy largos, por lo que evita exponerse a esto y ha salido menos de su casa. ¿Cuál es el tratamiento de elección? **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A Diazepam

B Citalopram

C Clorpromazina

D Risperidona

E Mirtazapina

Respuesta B. Es una agorafobia, que se trata con ISRS como los demás trastornos ansiosos crónicos. Las benzodiacepinas se intentan evitar en el embarazo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 33 años llega a urgencias a las 02:00 AM. Hace 30 minutos, estando en su cama, sintió palpitaciones, opresión retroesternal, asfixia, hormigueo en ambas manos y la certeza de que moriría de un infarto. Está sudorosa y angustiada. PA 135/85, FC 115 regular, SatO2 99%, examen cardiopulmonar normal. ECG: taquicardia sinusal sin cambios de ST ni T. Troponinas negativas. Tuvo episodios idénticos hace 2 y 4 semanas y desde entonces no viaja en metro ni sale sola por miedo a otra crisis. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Alta con alprazolam cada 8 horas en forma indefinida

B Contención verbal, respiración lenta, benzodiacepina sublingual si no cede; luego ISRS a dosis baja y TCC

C Hospitalizar en cardiología por probable síndrome coronario

D Propranolol como tratamiento definitivo

E Haloperidol intramuscular

Respuesta B. Trastorno de pánico con agorafobia: crisis recurrentes imprevistas con un mes de evitación. ECG y troponinas descartan un síndrome coronario. En urgencias, contención y respiración, y benzodiacepina sublingual si no cede. El tratamiento de fondo es ISRS, partiendo bajo, más TCC, con retiro programado de la benzodiacepina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 132

Una mujer de 45 años, hace 6 semanas mientras compraba, presenta un episodio de opresión en el pecho, disnea, vértigo, temor a morir, palpitaciones, disfagia, sensación de lipotimia, visión borrosa y disestesias de las extremidades superiores, asociado a marcada angustia. Desde entonces ha presentado un episodio de similares características cada semana. No tiene otros síntomas y su examen físico es normal, al igual que sus exámenes generales de laboratorio. ¿Cuál es el tratamiento de elección en el largo plazo?

A Inhibidores de la monoaminoxidasa

B Benzodiacepinas

C Antipsicóticos atípicos

D Antidepresivos tricíclicos

E Inhibidores de la recaptura de serotonina

Respuesta E. Tuvo una crisis de pánico y, por recurrir, ahora tiene un trastorno de pánico (o de angustia o de ansiedad), que se trata con IRS (se pueden agregar BDZ, ejemplo alprazolam c/8 horas al inicio y luego SOS, pero solo como tratamiento sintomático). No confundir con trastorno de ansiedad generalizada, aunque el tratamiento es el mismo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 103

Una paciente presenta sensación de opresión precordial intensa, asociada a disnea, vértigo y dificultad para ver, que sucede de manera episódica, con varias recurrencias en el último tiempo. Está muy preocupada y además tiene mucho miedo a morir de un infarto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno de ansiedad social
B Trastorno de ansiedad generalizada
C Agorafobia
D Trastorno de pánico
E Trastorno conversivo

Respuesta D. Diagnóstico: Trastorno de pánico (opción D). Por las crisis de pánico reiteradas, es un trastorno de pánico clásico. El Trastorno por Déficit Atencional (TDA) es una condición neurodiversa de causa genética que se caracteriza principalmente por la dificultad para mantener el foco atencional, con cambios frecuentes entre estímulos que dificultan el rendimiento escolar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 128

Una paciente de 23 años, sin antecedentes, consulta muy preocupada porque desde hace un mes ha presentado en cuatro oportunidades cuadros de inicio agudo caracterizados por dolor torácico intenso, asociados a cefalea, mareos, parestesias y disnea, los cuales tienen una duración aproximada de una hora y ceden espontáneamente. Al preguntarle de forma dirigida, desconoce que puede desencadenar estas crisis. Trae electrocardiograma que le habrían tomado en el servicio de urgencias cuando consultó por una crisis el cual se aprecia normal. Los fármacos de elección para el tratamiento de esta paciente son:

A Fluoxetina y carbamazepina
B Amitriptilina y clonazepam
C Citalopram y risperidona
D Sertralina y diazepam
E Paroxetina y lamotrigina

Respuesta D. Hay que darle un ISRS y al inicio una BDZ. La única opción que cumple con eso es la D. Los anticnovulsivantes y antipsicóticos no están indicados en el T. de angustia. Lo ideal sería empezar con fluoxetina 10 mg al día más alprazolam (no diazepam) 0,5 mg cada 8-12 horas y terminar con fluoxetina 20 mg al día, sin BDZ en un par de semanas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 37

Una paciente de 28 años presenta episodios súbitos de marcada angustia, con miedo a morir y síntomas como disnea con “imposibilidad de sacar el aire”, vértigo, parestesias en las extremidades, imposibilidad de tragar, opresión en el pecho, náuseas, visión borrosa y sensaciones eléctricas en el cuerpo, en los que siente la necesidad de salir corriendo para su caasa. Ha presentado 5 episodios en las últimas 4 semanas y está muy preocupada por lo que le está pasando. Los exámenes generales descartan patología orgánica. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?

A Amitriptilina 150 mg
B Sertralina 50 mg
C Risperidona 3 mg
D Clonazepam 6 mg
E Clorpromazina 300

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Sertralina 50 mg (opción B). Tiene un trastorno de pánico clásico, que se trata con antidepresivos IRS, como la sertralina. El metilfenidato, anfetaminas y modafinilo son los fármacos de apoyo en el TDA, pero el tratamiento principal es multidisciplinario.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 133

Paciente con trastorno de pánico. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A Sertralina 50 mg/día
B Alprazolam 0,5 mg cada 8 horas
C Litio 300 mg cada 12 horas
D Haloperidol 5 mg/día
E Valproato 500 mg/día

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Sertralina 50 mg/día (opción A). Sertralina 50 mg/día. El metilfenidato, anfetaminas y modafinilo son los fármacos de apoyo en el TDA, pero el tratamiento principal es multidisciplinario.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 83

Una paciente de 24 años presenta un cuadro de opresión precordial, disnea, parestesias en extremidades siperiores, palpitaciones y mucha ansiedad y miedo. Los síntomas se instalan en pocos minutos. ¿Cuál es el mejor medicamento para el manejo de esta crisis?

A Diazepam
B Fluoxetina
C Lorazepam
D Haloperidol
E Clorpromazina

Respuesta C. La crisis de pánico se trata con benzodiacepinas de acción rápida y corta (elección: lorazepam sublingual). Los antidepresivos IRS sirven para el trastorno de pánico (prevenir las crisis), no para la crisis de pánico mismo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 134

Paciente que refiere episodios de 'músculos que no responden', palpitaciones y sensación de muerte inminente. Hombre trabajador angustiado. ¿Diagnóstico más probable?

A Trastorno de ansiedad generalizada
B Arritmia cardíaca paroxística
C Epilepsia parcial compleja
D Trastorno de pánico
E Trastorno de somatización

Respuesta D. Diagnóstico: Trastorno de pánico (opción D). Trastorno de pánico. El Trastorno por Déficit Atencional (TDA) es una condición neurodiversa de causa genética que se caracteriza principalmente por la dificultad para mantener el foco atencional, con cambios frecuentes entre estímulos que dificultan el rendimiento escolar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 155

Una paciente de 50 años se siente atrapada en lugares como estacionamientos, au- topistas, los lugares al aire libre y los lugares cerrados, como ascensores. Por esto, ha dejado de salir de su casa. Además tiene cuadros de angustia episódica, con marcado miedo a perder el control. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Agorafobia
B Trastorno de ansiedad generalizada
C Trastorno de angustia
D Trastorno obsesivo compulsivo
E Fobia específica

Respuesta A. A, C? También me parece una agorafobia por el miedo en relación a los lugares descritos (yo marqué A). Sin embargo, también puede ser un trastorno de angustia con

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 157

Una paciente de 21 años presenta un episodio de rápida instalación, en 5 minutos, de marcada angustia, llanto, disnea y sensación de opresión precordial, más vértigo, imposibilidad de tragar, temblor y mucho miedo a morir. ¿Cuál es el tratamiento de esta crisis?

A Risperidona
B Carbamazepina
C Clorpromazina
D Fluoxetina
E Lorazepam

Respuesta E. Tiene una crisis de pánico, es decir solo un síntoma. Se pregunta el tratamiento de la crisis, que es con benzodiacepinas de rápida acción (lorazepam, clonazepam e incluso alprazolam, aunque el lorazepam es el más usado), generalmente por una vía de rápida absorción (sublingual, EV o IM). No se debe confundir la crisis de pánico con el trastorno de pánico, que tiene múltiples crisis de pánico, sin una causa evidente, asociado a miedo a las crisis, evitación y angustia. El trastorno de angustia,...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 133

Una paciente presenta mucha angustia ante ciertas situaciones como lugares con muchedumbre, los malls, los ascensores con mucha gente, los espacios desolados y otros, ya que presenta miedo a sufrir un colapso y que nadie la ayude. Como antecedente, cuando niña lloraba por largas horas cuando iba al colegio y su mamá la dejaba. El diagnóstico más probable es:

A Trastorno de personalidad evitativo
B Trastorno de ansiedad de separación del adulto
C Trastorno de ansiedad social
D Agorafobia
E Trastorno de angustia generalizada

Respuesta D. Diagnóstico: Agorafobia (opción D). Es una agorafobia clásica. El Trastorno por Déficit Atencional (TDA) es una condición neurodiversa de causa genética que se caracteriza principalmente por la dificultad para mantener el foco atencional, con cambios frecuentes entre estímulos que dificultan el rendimiento escolar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 100

Una niña de 13 años ha presentado diez episodios de angustia muy intensa, asociadas a sensación de muerte, disnea, vértigo, ganas de ir corriendo a su casa, temor a estar volviéndose loca y llanto descontrolado, todo lo que ha afectado seriamente su calidad de vida. Además. Sus padres han debido ir a buscarla en 3 oportunidades al colegio en las últimas dos semanas, debido a estos síntomas. No presenta síntomas depresivos, aunque su autoestima se ha visto mermada por la situación. Su examen físico es normal ¿Cuál es el tratamiento más importante para esta paciente?

A Sertralina
B Quetiapina
C Ácido valproico
D Alprazolam
E Diazepam

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Alprazolam (opción D). El metilfenidato, anfetaminas y modafinilo son los fármacos de apoyo en el TDA, pero el tratamiento principal es multidisciplinario.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 152

Una paciente de 22 años presenta ansiedad persistente, relacionada a abandonar la cosa sola, por miedo a que le pase algo, sin recibir ayuda de sus familiares, lo que se ha agravado en el último tiempo. Por esto abandonó sus estudios hace un mes y en ge- neral ha visto seriamente afectada su vida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Fobia social
B Trastorno de angustia generalizada
C Trastorno de personalidad dependiente
D Trastorno de angustia
E Agorafobia

Respuesta E. Diagnóstico: Agorafobia (opción E). Es una agorafobia clásica: miedo a no recibir ayuda. El Trastorno por Déficit Atencional (TDA) es una condición neurodiversa de causa genética que se caracteriza principalmente por la dificultad para mantener el foco atencional, con cambios frecuentes entre estímulos que dificultan el rendimiento escolar.

▶ VER CLASE 5.01.1.002 **Trastorno obsesivo compulsivo** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.8 · Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS

QUÉ HAY QUE SABER

- TOC: obsesiones (pensamientos o imágenes intrusivas: contaminación, duda, orden, daño, tabú) y compulsiones (lavar, revisar, contar, rezar, evitar) que consumen >1 hora al día o causan deterioro.
- Es egodistónico: el paciente sabe que es absurdo y sufre; la 'voz interior' no es alucinación. Obsesiones de dañar a un hijo o de ser pedófilo con angustia y evitación son TOC, no psicosis ni parafilia.
- Diferenciar del trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva (egosintónico, perfeccionismo, sin obsesiones ni rituales); evaluar riesgo suicida y depresión comórbida.
- Tratamiento inicial: ISRS en dosis altas (sertralina desde 50 mg, titulando a 150–200 mg; fluoxetina hasta 60–80 mg), explicando latencia de 8–12 semanas, más TCC con exposición y prevención de respuesta.
- No usar benzodiacepinas crónicas ni antipsicóticos en monoterapia; no reforzar el ritual ni tranquilizar repetidamente.
- Seguimiento: derivar a psiquiatría en casos moderados a severos o sin respuesta (clomipramina o potenciación).

PREGUNTAS · 10

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 155

Una paciente de 55 años, se lava las manos recurrentemente porque siente que se encuentran sucias, el hecho de no hacerlo rápidamente le provoca gran angustia. Esto le ha provocado dermatitis en sus manos, por lo cual está preocupada. Sabe que esta conducta no tiene sentido, pero no puede evitarlo. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A Trastorno de ansiedad
B Ansiedad específica
C Trastorno dismórfico corporal
D Trastorno disociativo
E Trastorno obsesivo compulsivo

Respuesta E. Obsesión de contaminación y compulsión de lavado, que la paciente reconoce sin sentido pero no puede evitar (egodistónica), con consecuencias en la piel: trastorno obsesivo compulsivo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 13

Un paciente de 32 años se lava las manos repetidamente durante el día. Al examen está lúcido, cooperador, pero angustiado. Refiere que una voz interior le ordena lavarse las manos y no puede desobedecerle. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento? **¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?**

A Litio
B Fluoxetina
C Olanzapina
D Carbamazepina
E Alprazolam

Respuesta B. Es un TOC, que se trata con antidepresivos ISRS. La «voz interior» no es una alucinación mientras el paciente no la escuche directamente ni la considere algo ajeno o externo a él.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 15

Un hombre de 34 años, que fue padre hace 2 meses, presenta imágenes recurrentes y desagradables, en las que él se ve asfixiando a su bebé con una almohada. Se siente muy angustiado y evita el contacto con su hijo, por miedo a hacerle daño. No ha querido contarle a su cónyuge, ya que se siente avergonzado y cree que se puede estar volviendo loco. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A Depresión psicótica

B Trastorno de estrés postraumático

C Trastorno adaptativo

D Trastorno obsesivo compulsivo

E Trastorno delirante

Respuesta D. Es un TOC clásico, con obsesión de acción negativa y compulsión de evitación. Otras obsesiones preguntadas han sido ser pedófilo, ser infiel o agredir a personas en la calle.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 73

Un paciente de 36 años presenta la idea de que puede ser pedófilo. Aquello lo angustia mucho y le aterra la idea de acercarse a los niños. Por ello reza y evita situaciones en las que estará en contacto con niños. Su diagnóstico es: **Su diagnóstico es:**

A Trastorno delirante

B Parafilia

C Trastorno obsesivo compulsivo

D Trastorno de la inclinación sexual

E Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta C. Es un TOC clásico con obsesión de conducta inmoral y compulsión de evitación y de rezar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 11

Una paciente de 32 años presenta imágenes recurrentes, en que se ve a sí misma cortando a su hijo de 12 meses, con un cuchillo. Aquello le genera mucha angustia y miedo de dañar a su hijo. Por ello, nunca se queda a solas con el niño y sacó todos los cuchillos de los cajones de la casa. Está muy angustiada y triste, porque no quiere que le pase nada malo a su hijo y teme tener problemas con sus familiares o perder la tuición del niño, por lo que no le ha contado su problema a nadie. Ha pensado incluso en morir, con tal de proteger a su familia. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A Trastorno bipolar

B Episodio psicótico

C Trastorno obsesivo compulsivo

D Trastorno depresivo mayor

E Trastorno de adaptación

Respuesta C. Es un TOC clásico, con obsesión de causar daño y compulsión evitativa.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Joven de 21 años, estudiante de ingeniería, consulta con su madre. Hace 8 meses tiene pensamientos continuos e involuntarios de que sus manos están contaminadas con bacterias letales. Para calmar la angustia se lava las manos con jabón desinfectante 15 veces seguidas tras tocar cualquier objeto, más de 4 horas al día. Tiene dermatitis de contacto con fisuras y eritema en ambas manos. Llorando dice: «Sé perfectamente que no me voy a infectar y que es una estupidez lavarme tanto, pero si no lo hago siento que me va a dar un ataque de pánico». **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Clonazepam cada 8 horas de forma crónica

B ISRS en dosis crecientes, TCC con EPR, emolientes y derivar a psiquiatría

C Haloperidol en monoterapia por ideas delirantes

D Solo tranquilizarlo y pedirle que se lave menos

E Psicoterapia psicodinámica sin fármacos

Respuesta B. TOC con obsesión de contaminación y compulsión de lavado, egodistónico (insight conservado) y de más de 4 horas diarias. Manejo: ISRS de primera línea en dosis altas (sertralina partiendo en 50 mg y titulando hasta 150 a 200 mg), TCC con exposición y prevención de respuesta, explicar la latencia de 8 a 12 semanas, tratar la dermatitis con emolientes y derivar a nivel secundario. Las benzodiacepinas crónicas no tienen lugar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 87

Hombre de 32 años que tuvo leucemia linfoblástica en la infancia. Curado. Ahora consulta por lavado de manos compulsivo más de 30 veces al día, incapacitante, relacionado con miedo a contaminarse. Reconoce que es excesivo pero no puede parar. ¿Cuál es el diagnóstico?

A Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)

B Fobia específica a gérmenes

C Hipocondría

D Trastorno de ansiedad generalizada

E TEPT por su historia oncológica

Respuesta A. Compulsiones (lavado de manos) repetitivas + egodistónicas (reconoce que es excesivo) + incapacitantes = TOC. La compulsión de limpieza es la más frecuente en TOC.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 127

Un paciente de 32 años consulta por la idea recurrente de que debe limpiar sus utensilios de alimentación para evitar adquirir una infección intestinal. Refiere que se cepilla los dientes durante 15 minutos y luego se enjuaga la boca por 10 minutos más. Reconoce que a veces quiere dejar de hacerlo, pero no puede evitarlo. Como antecedente, sufrió de leucemia aguda a los 7 años, siendo manejado con quimioterapia y logrando la curación de la enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Manía aguda
B Trastorno por descontrol de impulsos
C Trastorno de personalidad
D Esquizofrenia
E Trastorno obsesivo compulsivo

Respuesta E. Trastorno Obsesivo-Compulsivo: El cuadro clínico describe un trastorno obsesivo-compulsivo clásico, con obsesión por la contaminación y compulsión por la limpieza.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 68

Un paciente consulta muy angustiado, porque cree ser pedófilo. Le aterra acercarse a los niños y no sabe qué hacer, a pesar de que sabe que su idea es rara. Refiere que reza para no serlo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno delirante cónico
B Trastorno esquizoafectivo
C Trastorno psicótico agudo
D Trastorno obsesivo compulsivo
E Parafilia

Respuesta D. Diagnóstico: Trastorno obsesivo compulsivo (opción D). Tiene la obsesión (idea que produce angustia) y la compulsión (reza y evita los niños). La hipertrofia de adenoides es un tema relevante tanto en pediatría como en otorrinolaringología.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 37

Hombre piensa que puede ser pedofilo, le perturba el pensamiento recurrente asi q cuando lo piensa repite una frase: (repetida años anteriores) a. TOC

A Trastorno de ansiedad generalizada
B Trastorno obsesivo compulsivo
C Trastorno de estrés postraumático
D Episodio depresivo mayor
E Trastorno bipolar

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Trastorno de ansiedad generalizada). La hipertrofia de adenoides es un tema relevante tanto en pediatría como en otorrinolaringología.

▶ VER CLASE 5.01.1.003 Trastornos fóbicos (fobia social y fobia específica)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.7 · Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social

QUÉ HAY QUE SABER

- Fobia social: miedo intenso al escrutinio y juicio de otros (hablar, comer o actuar en público) con rubor, temblor o sudor y evitación que deteriora; el paciente desea relacionarse pero teme la humillación.
- Subtipo de actuación: solo hablar o actuar en público (expositores, músicos, estudiantes).
- Fobia específica: miedo desproporcionado a un estímulo concreto (volar, alturas, animales, sangre) con evitación; tratamiento de elección TCC con exposición gradual.
- Diferenciar de timidez normal (sin deterioro), personalidad esquizoide (no desea relacionarse), evitativa y agorafobia (miedo a no poder escapar).
- Tratamiento inicial: fobia social generalizada, ISRS (escitalopram, sertralina) más TCC; de actuación, propranolol 10–40 mg 30–60 minutos antes del evento. Sin benzodiacepinas de mantención.
- Seguimiento: derivar a salud mental especializada si no responde o hay comorbilidad (depresión, consumo de alcohol).

PREGUNTAS · 9

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 89

Paciente de 28 años con miedo intenso y síntomas físicos ante situaciones de hablar en público o comer frente a otros. Evita reuniones sociales y ha rechazado ascensos laborales por esto. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea? **¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea?**

A Escitalopram (ISRS)
B Propranolol a demanda
C Alprazolam a diario
D Haloperidol
E Carbamazepina

Respuesta A. Fobia social o trastorno de ansiedad social: el tratamiento farmacológico de primera línea son los ISRS (sertralina, escitalopram, paroxetina), combinados con TCC. El propranolol es para situaciones puntuales.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 123

Un hombre de 21 años experimenta dificultades para realizar presentaciones en público, que han afectado su rendimiento académico. Además, refiere enrojecimiento facial y torpeza en situaciones sociales. Recientemente no pudo terminar una presentación oral frente a su curso, ya que refiere que su mente se quedó en blanco en un momento. Todo esto le ha generado angustia y tristeza. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Fobia específica
B Agorafobia
C Trastorno de ansiedad generalizada
D Trastorno de ansiedad social
E Trastorno de personalidad evitativa

Respuesta D. El cuadro describe una fobia social, también llamada trastorno de ansiedad social.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 106

Un paciente de 21 años no sale de su casa por miedo a encontrarse con alguien que conozca y que le haga preguntas sobre su vida. Incluso desconecta el teléfono, para evitar que sus familiares lo llamen y le hagan preguntas. Se siente muy incómodo por lo que pudieran pensar de él las demás personas. Desde el colegio era muy tímido, pero esto empeoró al entrar a estudiar sus estudios superiores y actualmente afecta significativamente su vida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Depresión psicótica
B Trastorno de ansiedad social
C Trastorno obsesivo compulsivo
D Esquizofrenia
E Trastorno delirante crónico

Respuesta B. Es una fobia social generalizada y bastante grave: evita a los demás por lo que puedan pensar de él, y la timidez previa empeoró hasta afectar significativamente su vida.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 44

Paciente masculino de 27 años de edad , quien presenta desde hace 1 año temor a volar, por lo que prefiere desplazarse por tierra siempre. Incluso ha dejado de asistir a congresos y visitar a familiares en el extranjero. Siente mucha angustia y palpitaciones, cada vez que sabe que debe tomar un avión, desde los días antes y en dos oportunidades, previo a los vuelos, ha tomado benzodiacepinas con respuesta parcial. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A Trastorno de ansiedad generalizada
B Fobia específica
C Agorafobia
D Trastorno de pánico
E Trastorno por ansiedad de separación

Respuesta B. Es una aerofobia, que es la fobia específica a volar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 129

Una mujer de 34 años se siente muy ansiosa al realizar actividades como hacer presentaciones o hablar en reuniones de trabajo. Por ello evita ese tipo de situaciones y asigna dichas tareas a sus subalternos, sobrecargándolos. Incluso dejó de asistir a un congreso de ejecutivos, en el que tendría que exponer. El diagnóstico más probable es:

A Fobia social
B Trastorno de ansiedad generalizada
C Trastorno de personalidad antisocial
D Trastorno de personalidad evitativo
E Trastorno de pánico

Respuesta A. Diagnóstico: Fobia social (opción A). Es una fobia social clásica: ansiedad al realizar actividades en público y evitación de las mismas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 82

Una paciente de 20 años presenta mucha ansiedad ante las situaciones en que debe hacer exposiciones o presentaciones ante los demás. Presenta sudoración y palpitaciones antes de las presentaciones, con opresión cordial y disnea y esta dispuesta incluso a aumentar su carga de trabajo, con tal de evitar ese tipo de situaciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno de ansiedad generalizada
B Trastorno de personalidad evitativo
C Trastorno de personalidad dependiente
D Trastorno de angustia
E Trastorno de ansiedad social

Respuesta E. La opción correcta es la E (Trastorno de ansiedad social). En este escenario clínico, trastorno de ansiedad social se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 9

Un paciente de 24 años, estudiante de derecho, debe rendir su examen oral final para obtener su título profesional, ha estudiado por varios meses y tiene buen dominio de los temas, pero a pesar de que se ha preparado, no ha querido presentar aún el examen, ya que según él “no puedo hacerlo”. Refiere que le ha pasado lo mismo en situaciones similares donde le ha tocado exponer presentando gran nerviosismo. El diagnóstico más probable es:

A Trastorno de pánico
B Trastorno de la personalidad evitativo
C Ansiedad social
D Trastorno de ansiedad generalizada
E Agorafobia

Respuesta C. Diagnóstico: Ansiedad social (opción C). Es una fobia social de libro.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 35

Una paciente de 20 años, universitaria, tiene escasa interacción con sus compañeros, porque la inhibe el juicio que ellos puedan tener sobre su desempeño. El diagnóstico más probable es:

A Trastorno de personalidad esquizoide
B Trastorno de ansiedad
C Fobia social
D Trastorno del espectro autista
E Esquizofrenia

Respuesta C. Parecía que además tenía un T. de personalidad evitativo, pero en esta pregunta no estaba en las opciones. Además, que la ansiedad la genere el juicio de los demás, es lo clásico de la fobia social.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 156

Estudiante 4to año medicina, con miedo hablar en público y quedarse en blanco- a. Fobia social

A Trastorno de ansiedad generalizada
B Trastorno obsesivo compulsivo
C Trastorno de estrés postraumático
D Episodio depresivo mayor
E Trastorno bipolar

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Trastorno de ansiedad generalizada).

▶ VER CLASE `5.01.1.004` **Trastorno de adaptación** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.5 · Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno adaptativo: síntomas emocionales o conductuales (ánimo bajo, ansiedad, alteración conductual) que aparecen dentro de los 3 meses de un estresor identificable (despido, separación, migración, enfermedad).
- Malestar desproporcionado o deterioro funcional, sin cumplir criterios de depresión mayor (menos de 5 de 9 síntomas) ni de otro trastorno; remite en menos de 6 meses tras cesar el estresor o sus consecuencias.
- Diferenciar de duelo normal, estrés agudo/TEPT (requiere trauma con amenaza vital e intrusión/hiperalerta) y depresión mayor.
- Tratamiento: psicoeducación, psicoterapia breve de apoyo y resolución de problemas, higiene del sueño; sin antidepresivos de entrada y evitar benzodiacepinas prolongadas.
- Seguimiento: control en 3–4 semanas; si se agrava, persiste más de 6 meses o cumple criterios de depresión mayor, reclasificar y tratar (ISRS más psicoterapia).

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 90

Una mujer de 45 años consulta por irritabilidad, ánimo triste y sensación de agobio de dos meses de evolución, iniciados tras la separación de su pareja. Refiere llanto ocasional, dificultad para dormir y disminución en su rendimiento laboral, aunque continúa asistiendo a su trabajo y mantiene sus actividades cotidianas. Refiere que se siente mejor cuando hace ejercicio y tiene actividades sociales, pero que se siente sola y triste cuando regresa a su casa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Episodio depresivo mayor
B Trastorno adaptativo
C Trastorno conversivo
D Trastorno de ansiedad generalizada
E Sana

Respuesta B. Hay un gatillante claro y síntomas del ánimo, pero no alcanza los criterios de depresión mayor: conserva su trabajo y su vida, mejora con actividades y no tiene el cuadro completo. Es un trastorno adaptativo de tipo depresivo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 129

Un paciente de 35 años refiere sensación de angustia e inquietud, de un mes de evolución, asociado a insomnio de conciliación y cefalea diaria, de localización occipital, que se irradia hacia los hombros. Refiere que los síntomas iniciaron en relación a la necesidad de cambiarse de casa, ya que fue asignado a nuevo cargo en su trabajo, en una ciudad distinta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trastorno por somatización
B Depresión mayor
C Trastorno conversivo
D Trastorno adaptativo
E Trastorno disociativo

Respuesta D. Trastorno adaptativo de tipo ansioso: gatillante claro y síntomas de ansiedad. La cefalea tensional no lo convierte en somatización, que implica múltiples síntomas de todo tipo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 155

Hombre de 30 años que presenció un accidente de tránsito grave en que su mejor amigo resultó herido de gravedad. Desde entonces, hace 2 semanas, presenta insomnio, tristeza, dificultad de concentración en el trabajo y anhedonia. Sin ideación suicida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trastorno de pánico
B Trastorno de ansiedad generalizada
C Trastorno adaptativo
D Depresión mayor
E Trastorno de estrés agudo

Respuesta C. Trastorno adaptativo: síntomas emocionales o conductuales dentro de los 3 meses de un estresor identificable (el accidente del amigo), con deterioro funcional, pero sin cumplir criterios de depresión mayor. Se espera resolución espontánea.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 32 años, ingeniero comercial. Hace 2 meses lo trasladaron a una sucursal lejana, con nueva jefatura y más responsabilidades. Desde hace 6 semanas tiene desánimo, cefalea tensional, dificultad para conciliar el sueño, ansiedad los domingos y llanto ocasional. Mantiene su apetito, disfruta con sus hijos, juega fútbol con sus amigos y no tiene culpa, enlentecimiento ni ideas de muerte. PHQ-9: 7 puntos. **¿Cuál es la conducta más adecuada en APS?**

A Sertralina 50 mg al día y control en 2 semanas
B Psicoeducación, psicoterapia de apoyo breve, higiene del sueño y control en 3 a 4 semanas
C Clonazepam por 3 meses
D Derivar de urgencia por depresión grave
E Alta sin seguimiento: es una reacción normal

Respuesta B. Trastorno adaptativo con ánimo deprimido y ansiedad: estresor laboral claro, síntomas dentro de 3 meses, sin los 5 criterios de depresión mayor y con funcionamiento conservado. Se trata con psicoeducación, psicoterapia breve y seguimiento, sin antidepresivos ni benzodiacepinas prolongadas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 167

Paciente con angustia e insomnio de conciliación luego de enterarse que debe cambiarse de ciudad por trabajo. ¿Diagnóstico más probable?

A Trastorno de ansiedad generalizada
B Trastorno depresivo mayor
C Trastorno adaptativo
D Trastorno por estrés agudo
E Trastorno de pánico

Respuesta C. Diagnóstico: Trastorno adaptativo (opción C). Trastorno adaptativo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 128

Un paciente de 28 años presenta ánimo bajo e irritable, desde hace 2 meses, fecha en que murió su hermano. Se siente ansioso e intranquilo, sin cambios en el peso. Los síntomas interfieren moderadamente con sus actividades laborales. El diagnóstico más probable es:

A Trastorno de estrés agudo
B Trastorno de adaptación
C Episodio depresivo mayor
D Trastorno de ansiedad generalizada
E Distimia

Respuesta B. Es un T. adaptativo clásico (gatillante claro, síntomas depresivos y/o ansiosos, pero sin cumplir criterios de depresión u otro trastorno ansioso: ej. no tiene cambios en el peso ni afectación grave de su vida).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 108

Un hombre de 43 años consulta porque, desde hace 15 días, ha presentado angustia, desasosiego, insomnio y malestar general. Refiere, además, cefalea occipital, irradiada al cuello que es peor en las tardes. Refiere que los síntomas iniciaron después de que le comunicaron en su trabajo que sería trasladado a otra cuidad, por lo que deberá cambiarse de casa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno de somatización
B Trastorno de ansiedad generalizada
C Trastorno de adaptación
D Trastorno de angustia
E Episodio depresivo mayor

Respuesta C. Diagnóstico: Trastorno de adaptación (opción C).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 142

Paciente pierde el trabajo hace 4 semanas, y hace 3 semanas inicia con los siguientes síntomas: subido de peso y tenía insomnio, pero después decía sin anhedonia - depresión o distimia?

A Trastorno adaptativo porque no cumplia el mes para ser depresivo (ojo que sd. depresivo se
B Trastorno depresivo mayor
C Interrupción del embarazo
D Maduración pulmonar y observación
E Cesárea de urgencia

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Trastorno adaptativo porque no cumplia el mes para ser depresivo (ojo que sd. depresivo se).

▶ VER CLASE 5.01.1.005 Trastorno agudo por estrés

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.9 · Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno por estrés agudo: exposición a muerte, lesión grave o violencia sexual (real o amenazada; vivida, presenciada o de un cercano) con síntomas entre 3 días y 1 mes después.
- Clínica: intrusión (recuerdos, pesadillas, flashbacks), síntomas disociativos (aturdimiento, irrealidad, amnesia), evitación e hiperalerta (insomnio, sobresalto, irritabilidad).
- Si persiste más de 1 mes pasa a ser TEPT; un estresor cotidiano sin amenaza vital ni intrusión orienta a trastorno adaptativo.
- Tratamiento: primera ayuda psicológica (seguridad, escucha sin forzar el relato, necesidades básicas, activar redes) y TCC centrada en el trauma si los síntomas son intensos.
- No indicar benzodiacepinas (no previenen el TEPT e interfieren con la extinción del miedo) ni debriefing obligatorio; hipnótico breve solo si el insomnio es grave.
- Seguimiento: control cercano en las semanas siguientes para detectar evolución a TEPT, depresión, consumo de sustancias o riesgo suicida.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 132

Paciente que presenció un asalto hace 2 semanas, ahora con angustia, irritabilidad, insomnio y estado de hiperalerta. ¿Diagnóstico más probable? **¿Diagnóstico más probable?**

A Trastorno por estrés postraumático (TEPT)
B Trastorno adaptativo con ansiedad
C Trastorno por estrés agudo
D Trastorno de pánico
E Trastorno depresivo mayor

Respuesta C. Trastorno por estrés agudo: trauma presenciado hace 2 semanas, con síntomas de hiperalerta e irritabilidad, es decir dentro del primer mes.

▶ VER CLASE 5.01.1.006 Trastorno por estrés postraumático

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.9 · Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo

QUÉ HAY QUE SABER

- TEPT: tras exposición a muerte, lesión grave o violencia sexual, síntomas por más de 1 mes de los 4 grupos: intrusión (flashbacks, pesadillas), evitación, cognición y ánimo negativos (culpa, desapego, amnesia) e hiperalerta.
- Puede iniciarse en forma tardía (más de 6 meses después); se asocia a depresión, consumo de alcohol y riesgo suicida, que deben pesquisarse.
- Diferenciar de estrés agudo (<1 mes), trastorno adaptativo (sin trauma mayor ni intrusión) y amnesia disociativa.
- Tratamiento inicial: psicoterapia centrada en el trauma (TCC o EMDR) más ISRS (sertralina desde 50 mg o paroxetina); prazosina 1–5 mg nocturna si hay pesadillas persistentes.
- Benzodiacepinas contraindicadas en el TEPT.
- Seguimiento: derivar a salud mental especializada para psicoterapia de trauma.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 86

Un paciente de 24 años, sin antecedentes, consulta porque hace ocho meses mientras esperaba transporte colectivo, presenció un accidente automovilístico con resultados fatales, desde entonces intenta no acercarse mucho a la calle y cada vez que está en un paradero se encuentra muy inquieto, además refiere que le cuesta conciliar el sueño ya que presenta pesadillas frecuentemente. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A Trastorno por estrés post traumático
B Trastorno de ansiedad
C Trastorno evitativo
D Trastorno por estrés agudo
E Trastorno adaptativo

Respuesta A. Es un trastorno de estrés postraumático de libro, y lleva más de 4 semanas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 61

Un paciente de 50 años, presentó una pelea con su vecino hace 4 meses y desde hace un mes comienza con recuerdos del incidente, asociado a pesadillas recurrentes. En las últimas semanas evita pasar por fuera de la casa de su vecino por miedo, y su familia refiere que se encuentra con ánimo bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trastorno adaptativo
B Trastorno de estrés postraumático
C Depresión reactiva
D Depresión psicótica
E Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta B. Es un trastorno de estrés postraumático clásico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 10

Una paciente de 52 años, con antecedente de abuso sexual reiterado por un familiar, entre los 12 y los 15 años, del que aún mantiene recuerdos y pesadillas, refiere episodios de algunos días de duración ánimo irritable y lábil, asociada a ira y peleas con sus familiares, con llanto y agresividad. En ocasiones, presenta episodios de hasta dos días de duración de descontrol y rabia, en los que rompe ropa y electrodomésticos de su marido. Estos episodios le traen problemas con sus cercanos y, en algunas ocasiones, son muy intensos, en especial cuando se expone a conversaciones relacionadas con el tema, en los que llora, siente intensa angustia, grita e incluso ha presentado momentos en que actúa como una niña, con lenguaje y entonación de una menor de edad. Estos episodios cursan con amnesia de lo sucedido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trastorno bipolar
B Trastorno delirante
C Trastorno esquizoafectivo
D Trastorno conversivo
E Trastorno de estrés postraumático

Respuesta E. Es un trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos: trauma sexual en la adolescencia, recuerdos y pesadillas, episodios desencadenados por recordatorios, con amnesia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 67

Psicofármaco contraindicado en trastorno de estrés post traumático **Psicofármaco contraindicado en trastorno de estrés post traumático**

A Benzodiazepinas
B ISRS
C Tricíclicos
D Antipsicóticos típicos
E Antipsicóticos atípicos

Respuesta A. Las benzodiacepinas están contraindicadas en el estrés postraumático: no previenen el trastorno e interfieren con la psicoterapia de reprocesamiento.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 35 años, cajera de banco, consulta 4 meses después de un asalto armado en que la apuntaron en la cabeza durante 20 minutos. No logra dormir por pesadillas en que revive el arma en su frente; despierta gritando y sudorosa. Se sobresalta con cualquier ruido metálico o frenazo. Renunció a su trabajo, evita salir sola y ver noticias, y se siente «desconectada de sus hijos, como muerta por dentro». **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Clonazepam cada 8 horas por tiempo indefinido

B Psicoterapia centrada en el trauma más un ISRS; evaluar prazosina si persisten las pesadillas

C Debriefing psicológico obligatorio e inmediato

D Haloperidol por ideas persecutorias

E Solo reposo laboral y seguimiento

Respuesta B. TEPT crónico: evento con riesgo vital, más de 1 mes (4 meses) y los 4 grupos de síntomas (intrusión, evitación, ánimo negativo y desapego, hiperalerta). Primera línea: TCC centrada en el trauma o EMDR, más un ISRS (sertralina desde 50 mg); si persisten pesadillas severas, evaluar prazosina nocturna. Las benzodiacepinas están desaconsejadas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 28

Un paciente de años, desde hace 10 días comienza con angustia y malestar general, asociado a dificultades para dormir y pesadillas. Se ha sentido agobiado y triste. Refiere que ace dos semanas fue testigo de un asalto, en el cual la víctima fue herida con un arma de fuego. Además, ha evitado salir de su casa y el contacto con otras personas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno agudo por estrés

B Episodio depresivo mayor

C Trastorno de estrés postraumático

D Trastorno de angustia generalizada

E Trastorno de angustia social

Respuesta C. Diagnóstico: Trastorno de estrés postraumático (opción C). El manejo de los contactos de pacientes con coqueluche se basa en la administración de azitromicina por cinco días, con la misma dosis que se utiliza en el tratamiento.

▶ VER CLASE 5.01.1.007 Primer episodio depresivo

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Psiquiatría 17.1 · Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES
Psiquiatría 17.4 · Depresión Posparto y Trastornos Afectivos Perinatales: Blues vs Depresión vs Psicosis Puerperal

QUÉ HAY QUE SABER

- Depresión mayor (DSM-5): ≥5 de 9 síntomas casi todos los días por ≥2 semanas, con ánimo deprimido o anhedonia obligatorio, más deterioro: cambio de peso >5%/mes, sueño, psicomotricidad, fatiga, culpa, concentración, ideas de muerte.
- Antes de diagnosticar: descartar causa médica o fármacos (TSH, hemograma, B12), preguntar por manía/hipomanía previa (bipolaridad) y evaluar directamente el riesgo suicida.
- Gravedad con PHQ-9: 5–9 leve (psicoeducación), 10–14 moderada, 15–19 moderadamente grave, 20–27 grave (derivar). Garantía GES desde los 15 años.
- Tratamiento: ISRS más psicoterapia: sertralina 50–200 mg, escitalopram 10–20 mg o fluoxetina 20–60 mg; explicar latencia de 2–4 semanas. Benzodiacepinas nunca en monoterapia.
- Control a las 2 semanas y reevaluar a las 4–6: respuesta parcial, subir al techo; falla a dosis máxima, cambiar a otro ISRS o dual (venlafaxina 75–225 mg); mirtazapina útil con insomnio/inapetencia.
- Seguimiento completo: mantener la misma dosis 6–12 meses tras la remisión; derivar si hay psicosis, riesgo suicida moderado-alto, sospecha bipolar o falla de 2 esquemas.

PREGUNTAS · 12

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 174

Un paciente de 43 años consulta por un cuadro de 3 meses de evolución caracterizado por ánimo bajo, anhedonia, insomnio de conciliación y despertar precoz. Además, ha aumentado de peso y tiene pensamientos negativos e ideas recurrentes negativas sobre sí mismo, sin ideación suicida actual. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento en este paciente? **¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?**

A Alprazolam

B Sertralina

C Quetiapina

D Carbonato de litio

E Amitriptilina

Respuesta B. Es una depresión mayor, con algunos rasgos atípicos por el aumento de peso. Se trata preferentemente con ISRS, como la sertralina. Los tricíclicos ya no son de primera línea y las benzodiacepinas no tratan la depresión.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 75

Un paciente de 25 años presenta tristeza, dificultades en su trabajo, sensación de culpa patológica e insomnio de conciliación y mantención, de seis semanas de evolución, por lo que inicia tratamiento con escitalopram 10 mg al día. Tres semanas después, refiere que su ánimo ha mejorado considerablemente y que ya no se siente triste ni culpable y que tampoco ha seguido con problemas para dormir. Comenta sentirse bien, similar a como estaba antes del inicio de estos síntomas. ¿Cuál es la conducta más adecuada? **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Suspender el tratamiento

B Disminuir la dosis de citalopram

C Mantener el tratamiento por 3 meses

D Mantener el tratamiento por 12 meses

E Cambiar el tratamiento a fluoxetina

Respuesta D. Está en remisión, pero el fármaco se mantiene después de la remisión completa, por 6 a 12 meses en un primer episodio. De las alternativas, la única aceptable es 12 meses.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 99

Mujer de 30 años, 3 semanas post parto vaginal, consulta por llanto fácil, tristeza, insomnio, sentimiento de incompetencia como madre y pensamientos de hacerse daño. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento? **¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?**

A Depresión postparto: iniciar antidepresivo (sertralina) + psicoterapia

B Blues postparto: tranquilizar, resolverá espontáneamente en días

C Psicosis puerperal: hospitalización de urgencia

D Trastorno adaptativo: solo psicoterapia

E Trastorno bipolar postparto: iniciar litio

Respuesta A. Más de 2 semanas del parto, síntomas depresivos e ideas de autolesión: depresión posparto. Se trata con sertralina, segura en lactancia, y psicoterapia. Con ideas de hacerse daño se evalúa antes el riesgo suicida; si es moderado o alto, se deriva.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 74

Una paciente de 38 años inicia un cuadro de ánimo bajo, desconcentración e insomnio de conciliación, que inició después de que su marido fuera diagnosticado de una enfermedad grave. No ha tenido cambios en el peso ni ideación suicida. Inicia psicoterapia sin notar mejoría de sus síntomas. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección para el manejo de esta paciente? **¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección?**

A Bupropión

B Venlafaxina

C Sertralina

D Carbonato de litio

E Mirtazapina

Respuesta C. Parecía un trastorno adaptativo, pero sin mejoría con psicoterapia el cuadro evoluciona a una depresión. Su primera línea es un ISRS, como la sertralina.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una madre primípara de 24 años consulta al 5.° día postparto por llanto fácil, hipersensibilidad emocional y fatiga. Refiere que a ratos se siente desbordada por los cuidados del recién nacido, pero amamanta a su hijo con afecto y logra descansar cuando sus familiares la apoyan. Su examen mental no muestra anhedonia persistente, desapego ni ideas delirantes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta adecuada? **¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta adecuada?**

A Depresión posparto mayor; iniciar sertralina 50 mg al día de inmediato

B Disforia puerperal ("baby blues"); psicoeducación, apoyo familiar y seguimiento sin psicofármacos

C Psicosis puerperal incipiente; derivar de urgencia a hospitalización cerrada

D Trastorno de pánico posparto; alprazolam en gotas cada 8 horas

E Encefalopatía puerperal; resonancia magnética de encéfalo urgente

Respuesta B. Baby blues: día 3 a 5, llanto fácil y labilidad, vínculo preservado, sin anhedonia persistente ni delirios. Remite en 10 a 14 días con educación y apoyo, sin fármacos. La sertralina se reserva para la depresión instalada.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 41 años, profesora, sin antecedentes. Hace 6 semanas presenta tristeza persistente, llanto fácil, pérdida del interés, despertar a las 4 de la mañana con angustia, fatiga, baja de 4 kg y culpa excesiva. PHQ-9: 17. Niega ideas de muerte y no tiene antecedentes de euforia ni de hiperactividad. Examen físico normal. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada en el CESFAM?**

A Clonazepam y control en 3 meses

B Sertralina, psicoterapia, explicar la latencia y control en 2 semanas

C Hospitalización para terapia electroconvulsiva

D Reposo laboral sin fármacos hasta una segunda evaluación

E Amitriptilina más haloperidol

Respuesta B. Cumple criterios de episodio depresivo mayor, moderadamente grave, con rasgos melancólicos y sin psicosis ni riesgo suicida. La conducta GES es ISRS más psicoterapia, educación sobre la latencia de 2 a 4 semanas y control a las 2 semanas. Las benzodiacepinas no tratan la depresión.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Primigesta de 27 años, parto vaginal hace 7 semanas, acude al control de niño sano de los 2 meses. La EPDS da 15 puntos. Hace 1 mes no disfruta estar con su hijo, siente que "no nació para ser madre", no logra dormir aunque el bebé duerma y se siente exhausta y culpable. Es protectora con el lactante, niega ideas de dañarlo y no tiene síntomas psicóticos. Amamanta en forma exclusiva y desea continuar. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Explicar que es baby blues y controlar en 6 meses

B Suspender la lactancia e iniciar un tricíclico

C Sertralina, psicoterapia, mantener la lactancia y control en 2 semanas

D Hospitalización psiquiátrica de urgencia por psicosis puerperal

E Indicar benzodiacepinas para dormir y volver a control habitual

Respuesta C. Depresión posparto: más de 2 semanas, criterios de depresión mayor y EPDS de 15. No hay psicosis ni riesgo para el bebé. Se trata con sertralina y psicoterapia, se mantiene la lactancia y se controla en 2 semanas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 174

Un paciente de 40 años, sin antecedentes, con cuadro de disforia y anhedonia desde hace tres semanas, momento en el cual fue despedido de su trabajo, además presenta apetito disminuido, baja de peso e insomnio. Al entrevistarlo de forma dirigida refiere que siente que no vale nada y no ha presentado intentos ni ideas suicidas. El tratamiento de elección en este caso es:

A Venlafaxina

B Amitriptilina

C Clonazepam

D Escitalopram

E Bupropion

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Escitalopram (opción D). Tiene una depresión: preferir ISRS.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 39

Un paciente de 16 años, sin antecedentes mórbidos, es traído por presentar mal rendimiento escolar y mala relación con sus padres. Sus padres refieren que esto comenzó hace tres meses, que ha estado irritable, se alimenta mal y duerme poco. Al entrevistar solo al paciente, refiere que hace aproximadamente tres meses terminó una relación amorosa que fue muy importante. El diagnóstico más probable es:

A Trastorno ansioso

B Esquizofrenia

C Trastorno delirante

D Distimia

E Depresión

Respuesta E. Diagnóstico: Depresión (opción E). De libro. Ánimo bajo persistente por más de dos semanas, anhedonia, alteraciones del sueño y fatiga cumplen criterios diagnósticos para episodio depresivo mayor (Garantía GES en APS). El tratamiento de primera línea incluye psicoterapia e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS como sertralina).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 158

Una paciente de 34 años consulta por un cuadro de 6 semanas de evolución de ánimo bajo y tristeza, asociado a alza de peso y dificultades para dormir consistentes en insomnio de conciliación. Además, se ha sentido más desconcentrada de lo habitual, con pensamientos negativos sobre sí misma, sin ideación suicida. ¿Qué fármaco es de elección para iniciar el tratamiento en esta paciente?

A Bupropión

B Citalopram

C Venlafaxina

D Mirtazapina

E Carbonato de li2o

Respuesta B. El tratamiento de elección en la depresión son los antidepresivos IRS (inhibidores de la recaptura de serotonina), tales como sertralina, fluoxetina, citalopram y escitalopram. De segunda línea (en caso de que no responda después de 4 semanas), se puede subir la dosis o idealmente cambiar a un antidepresivo dual, como la venlafaxina, duloxetina, bupropión o mirtazapina. Los dos últimos, además, son útiles en casos en que los otros antidepresivos produzcan disminución de la libido.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 130

Una paciente de 50 años presenta un cuadro de 5 meses de evolución de dificultades para concentrarse, asociadas a desgano, ánimo bajo y tristeza, síntomas que se acentúan en el periodo premenstrual. Sale muy poco de su casa y ha disminuido la interacción con otras personas, comentando que disfruta poco o nada con las actividades que habitualmente le eran placenteras. Refiere que duerme cerca de 2 horas menos que antes y que ha subido una talla de ropa. Sus exámenes generales descartan patología orgánica. El diagnóstico más probable es:

A Trastorno adaptativo

B Episodio depresivo mayor

C Trastorno de angustia generalizada

D Trastorno de ansiedad social

E Trastorno disfórico premenstrual

Respuesta B. Tiene una depresión clara con ánimo bajo, anhedonia, desconcentración, alteraciones del peso y del sueño.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 170

Una paciente de 32 años consulta por un cuado de un mes de evolución, en que sale poco de su casa y presenta desgano y retraimiento social, disminuyendo el disfrute de las actividades que habitualmente le eran placenteras. También refiere desconcentración en su trabajo y, además, ha disminuido la cantidad del tiempo de sueño, en alrededor de 2 horas diarias. Refiere que los síntomas empeoran en el período premenstrual. El diagnóstico más probable es:

A Episodio depresivo mayor
B Trastorno adaptativo
C Hipomanía
D Trastorno esquizoafectivo
E Trastorno disfórico premenstrual

Respuesta A. Tiene una depresión clásica con anhedonia y afectación de distintas áreas de la vida (sueño, actividad social, concentración, etc.). Que empeore en el periodo premenstrual es algo que puede ocurrir con cualquier patología psiquiátrica y también con cualquier problema normal, sin necesariamente ser un síndrome premenstrual.

▶ VER CLASE 5.01.1.008 **Trastorno depresivo (recurrente)** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.1 · Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Depresión recurrente: dos o más episodios depresivos mayores separados por al menos 2 meses sin síntomas; mayor riesgo de nuevas recaídas con cada episodio.
- Sospecharla ante historia de episodios previos o tratamiento antidepresivo anterior; buscar dirigidamente antecedentes de manía o hipomanía (bipolaridad), consumo de sustancias y riesgo suicida.
- Distimia (trastorno depresivo persistente): ánimo bajo crónico ≥2 años (1 año en niños y adolescentes) sin pausas >2 meses; si se superpone un episodio mayor es depresión doble.
- Manejo inicial: reiniciar el antidepresivo que fue eficaz (ISRS) más psicoterapia, evaluar adherencia y gravedad.
- Tras 2–3 episodios el mantenimiento es prolongado (≥2 años o indefinido); el litio reduce intentos suicidas en depresión recurrente.
- Seguimiento: derivar a nivel secundario (recurrencia, refractariedad o comorbilidad).

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 146

Un hombre de 45 años consulta por ánimo deprimido, anhedonia, alteraciones del sueño y dificultades para concentrarse, los cuales han afectado su desempeño laboral y social durante los últimos 4 meses. No refiere antecedentes de episodios maníacos ni psicosis, pero sí un episodio depresivo mayor hace cinco años, tratado con éxito con fluoxetina. En esta ocasión, se inició tratamiento con escitalopram (20 mg/día) durante 4 semanas, pero no ha mostrado mejoría significativa en sus síntomas. No refiere efectos secundarios importantes con el medicamento y su función tiroidea y niveles de vitamina B12 y ácido fólico son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada? **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Aumentar la dosis de escitalopram
B Cambiar el tratamiento a venlafaxina
C Iniciar terapia electroconvulsiva (TEC)
D Agregar un antipsicótico atípico como quetiapina
E Cambiar el tratamiento a fluoxetina

Respuesta B. El escitalopram ya está a 20 mg, su dosis máxima, con buena tolerancia y sin causa médica. Al no haber respuesta, se cambia a un antidepresivo dual como la venlafaxina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 71

Una paciente de 82 años, con antecedente de 2 intentos de suicidio previos, presenta un cuadro de ánimo bajo, irritabilidad, problemas de memoria. Su minimental es 27/30, su GDS (escala de depresión geriátrica) es de 12/15 y presenta ideas delirantes de daño. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Terapia electroconvulsiva
B Iniciar sertralina
C Hospitalizar con mirtazapina
D Indicar clorpromazina
E Hospitalizar con amitriptilina

Respuesta A. Es una depresión psicótica en una adulta mayor, con intentos de suicidio previos y riesgo vital. Es una urgencia que se maneja hospitalizada, y la terapia electroconvulsiva es la opción más segura y rápida. La amitriptilina y la clorpromazina son mala idea en el adulto mayor.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 39 años consulta en salud mental refiriendo: "Toda mi vida he sido una persona triste y sin energía; desde la universidad, hace más de 10 años, siento que veo el mundo en blanco y negro, me canso con facilidad y tengo muy baja autoestima". Refiere que nunca ha tenido episodios de euforia ni períodos libres de síntomas que superen las 3 o 4 semanas seguidas. Su examen físico y tiroideo son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el pilar terapéutico? **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el pilar terapéutico?**

A Trastorno adaptativo; reposo laboral exclusivo

B Trastorno depresivo persistente (distimia); ISRS a largo plazo y psicoterapia cognitivo-conductual

C Trastorno de personalidad esquizoide; antipsicóticos típicos

D Episodio depresivo mayor único; suspender fármacos a los 3 meses

E Trastorno ciclotímico; valproato sódico en monoterapia

Respuesta B. Ánimo bajo, poca energía y baja autoestima de curso continuo por más de 10 años, sin períodos libres de más de 2 meses: distimia. El tratamiento óptimo combina un ISRS a dosis plenas por tiempo prolongado con psicoterapia cognitivo-conductual.

▶ VER CLASE 5.01.1.009 Trastorno bipolar

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.2 · Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Bipolar I: basta un episodio maníaco; bipolar II: hipomanía más episodio depresivo mayor; ciclotimia: 2 años de fluctuaciones sin criterios completos. Heredabilidad cercana al 80%.
- Manía: ánimo elevado, expansivo o irritable con ≥3 de 7 síntomas (4 si solo irritable): grandiosidad, menos necesidad de sueño, verborrea, fuga de ideas, distraibilidad, hiperactividad y conductas de riesgo; ≥7 días o cualquier duración si hospitaliza o hay psicosis.
- Hipomanía: ≥4 días, sin deterioro grave ni psicosis. Euforia o insomnio sin fatiga tras iniciar un ISRS sugiere bipolaridad: suspender el antidepresivo.
- Manía aguda: urgencia; hospitalizar, antipsicótico atípico (olanzapina, risperidona, quetiapina) más estabilizador (litio o valproato); agitación intensa: haloperidol más lorazepam. Nunca antidepresivo en monoterapia.
- Litio: litemia profilaxis 0,6–1,0 mEq/L (aguda 0,8–1,2), muestra a las 12 h; AINE, tiazidas e IECA/ARA-II la elevan. Valproato teratogénico: evitar en mujeres en edad fértil sin anticoncepción.
- Seguimiento: derivar a psiquiatría (garantía GES); controles de litemia, función renal y tiroidea.

PREGUNTAS · 13

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 82

Paciente de 35 años con episodios previos de tristeza profunda de 3 semanas de duración. Ahora consulta por irritabilidad, euforia, grandiosidad, insomnio sin cansancio y gastó todos sus ahorros en 4 días. ¿Cuál es el diagnóstico? **¿Cuál es el diagnóstico?**

A Trastorno bipolar tipo I

B Trastorno depresivo mayor recurrente

C Trastorno de ansiedad generalizada

D Trastorno obsesivo compulsivo

E Trastorno de personalidad borderline

Respuesta A. Episodios depresivos previos más un episodio maníaco actual (grandiosidad, euforia, insomnio sin cansancio, gasto impulsivo) es trastorno bipolar tipo I. Un episodio maníaco es suficiente para el diagnóstico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 114

Una paciente de 23 años presenta un cuadro de 3 semanas de evolución caracterizado por ánimo bajo, tristeza, disminución de sus actividades, asociado a hipersomnia diurna y aumento de peso de 5 kg en poco tiempo. Además, refiere dificultades de concentración en sus actividades educacionales. Tiene antecedentes de tres episodios similares en los últimos años y su hermana refiere que también ha presentado dos episodios en los cuales ha tenido periodos con mucho ánimo y aumento de la energía, incurriendo en gastos excesivos y desarrollando múltiples proyectos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trastorno de personalidad histriónico

B Trastorno afectivo bipolar

C Trastorno por déficit atencional hiperactivo

D Trastorno de personalidad limítrofe

E Depresión atípica

Respuesta B. El episodio actual parece una depresión atípica (hipersomnia, aumento de peso), pero hubo dos períodos de ánimo elevado, mucha energía, gastos excesivos y múltiples proyectos. Eso apunta a trastorno afectivo bipolar. En la depresión bipolar se usan antipsicóticos atípicos, no antidepresivos solos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 130

Un paciente de 27 años presenta ánimo bajo, anhedonia y desconcentración, asociado a baja de peso y dificultades para dormir, por lo que se le indica tratamiento con sertralina 50 mg al día. Evoluciona con clara mejoría de los síntomas, sin embargo, su pareja refiere que anda más irritable, ha aumentado el gasto de dinero y ha iniciado nuevos proyectos. Suspende el medicamento, persistiendo con disminución de los requerimientos de sueño, irritabilidad y verborrea. ¿Qué fármaco es más adecuado para su manejo actual? **¿Qué fármaco es más adecuado para su manejo actual?**

A Sertralina

B Mirtazapina

C Bupropión

D Diazepam

E Quetiapina

Respuesta E. Viró a una hipomanía en el contexto de un trastorno bipolar no diagnosticado. Están contraindicados todos los antidepresivos (sertralina, mirtazapina, bupropión). El tratamiento de elección es un antipsicótico atípico, como la quetiapina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 92

Paciente con trastorno bipolar tipo I presenta episodio de manía aguda con agitación, desinhibición y grandiosidad. ¿Cuál es el tratamiento de elección en fase aguda? **¿Cuál es el tratamiento de elección en fase aguda?**

A Litio + antipsicótico atípico (quetiapina u olanzapina)

B Solo antidepresivos ISRS

C Benzodiacepinas en monoterapia

D Lamotrigina en dosis progresiva

E Ácido valproico en monoterapia oral

Respuesta A. Manía aguda: tratamiento combinado con un estabilizador del ánimo (litio o ácido valproico) más un antipsicótico atípico para controlar rápido los síntomas. Litio más quetiapina es un esquema estándar.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 24 años, llevado a urgencias por su familia. Desde hace 5 días duerme 1 hora por noche sin cansancio, gastó el dinero de su matrícula en relojes, habla sin pausa saltando de tema y afirma que fue elegido por el gobierno para rediseñar la capital. Está agitado y desinhibido. Toxicológico en orina negativo. A los 20 años tuvo una depresión moderada. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?**

A Bipolar II con hipomanía; psicoterapia ambulatoria y sertralina

B Bipolar I con manía psicótica; hospitalizar, antipsicótico atípico más estabilizador

C Déficit atencional del adulto; metilfenidato

D Personalidad esquizoide descompensada; reposo y clonazepam

E Depresión psicótica; fluoxetina en dosis altas

Respuesta B. Insomnio sin fatiga, verborrea, fuga de ideas, gasto imprudente y delirio de grandeza: es una manía con psicosis, de 5 días, con riesgo conductual. Eso es bipolar I, y se hospitaliza e inicia antipsicótico atípico más litio o valproato. Los antidepresivos y estimulantes empeoran la manía.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 26 años con trastorno bipolar tipo I bien controlado, que desea planificar un embarazo. Está en tratamiento con ácido valproico 1.000 mg/día, con niveles estables de 75 µg/mL. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a su farmacoterapia?**

A Mantener el ácido valproico a la misma dosis

B Reemplazar el ácido valproico por carbamazepina

C Planificar el cambio gradual a un estabilizador menos teratogénico (lamotrigina o quetiapina) y suplementar ácido fólico en dosis altas

D Suspender todos los fármacos durante todo el embarazo

E Agregar litio al valproato para proteger al feto

Respuesta C. El valproato es el estabilizador más teratogénico (defectos del tubo neural, malformaciones, deterioro del neurodesarrollo). Antes del embarazo se cambia, de forma gradual y planificada, a un fármaco de mejor perfil, con ácido fólico en dosis altas. La carbamazepina también es teratogénica, y suspender todo expone a una recaída maníaca grave.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 77

Un paciente de 22 años es traído por sus familiares debido a que anda muy irritable y con una actitud rara, además de haber iniciado una serie de proyectos de negocios nuevos. Al examen presenta aceleración del habla y sus acompañantes comentan que en ocasiones trabaja hasta muy tarde, pese a lo cual al día siguiente continúa con sus actividades normales, durmiendo muy pocas horas. Durante la entrevista, en ocasiones se emociona y llora y en otras se ríe a carcajadas. Sus compañeros de estudios refieren que anda más gracioso y “sin filtro”. Tiene antecedente de haberse deprimido a los 18 años en relación con una ruptura sentimental. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno adapta2vo mixto

B Trastorno bipolar

C Trastorno por déficit atencional hiperac2vo

D Trastorno de personalidad en crisis

E Trastorno esquizoafec2vo

Respuesta B. Es un trastorno afectivo bipolar clásico. Ahora está en episodio maníaco, cuya presencia confirma el diagnóstico de trastorno bipolar. El antecedente de depresión lo refuerza.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 34

Un paciente de 22 años es traído por sus familiares, dado que anda muy irritable y ha iniciado una serie de proyectos de negocio, en áreas que no maneja bien. Presenta aceleramiento del habla y hay noches en las que pasa sin dormir, a pesar de lo cual, al día siguiente no presenta sueño. En ocasiones, se ríe a carcajadas y ,en otras, se emociona fácilmente al hablar de ciertos temas. Sus amigos lo describen como “patudo y sin filtro”. Tiene antecedente de haberse deprimido hace algunos años, en relación a una ruptura sentimental. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno esquizoafectivo

B Trastorno adaptativo mixto

C Trastorno bipolar

D Trastorno por déficit atencional

E Trastorno de personalidad en crisis

Respuesta C. Es una manía clásica y, por tanto, un TAB. No tiene síntomas psicóticos. Si bien la personalidad parece estar afectada (ser "patudo y sin filtro"), no hay duda que de base hay un TAB.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 165

Paciente con irritabilidad, conductas sexuales de riesgo, disminución de necesidad de dormir, más habladora de lo habitual. ¿Diagnóstico más probable?

A Trastorno de personalidad histriónica

B Trastorno bipolar (episodio maníaco)

C Trastorno por déficit atencional

D Hipomanía inducida por sustancias

E Trastorno ciclotímico

Respuesta B. Diagnóstico: Trastorno bipolar (episodio maníaco) (opción B). Trastorno bipolar (episodio maníaco). El trastorno bipolar es una enfermedad genética (herencia autosómica dominante) con alta prevalencia de antecedentes familiares, que debuta típicamente entre los 18 y 30 años.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 13

Un paciente de 20 años inicia tratamiento con fluoxetina, por un cuadro de ansiedad social, evolucionando con aumento de la sociabilidad, volviéndose muy conversador, pero siendo en ocasiones muy intrusivo, al punto de ser desagradable. Muestra ausencia de empatía y ha tenido problemas con sus compañeros de estudios. Con frecuencia, se muestra irritable, ansioso y a veces emocionado, con llanto. Ha aumentado su nivel de actividad física y, además, presenta disminución de las horas de sueño, sin disminuir su nivel de energía. En ocasiones, presenta ganas de salir corriendo, sin saber por qué. Tiene antecedente de un episodio depresivo a los 16 años, que respondió al tratamiento con sertralina. El diagnóstico más probable es un trastorno:

A Bipolar

B Adaptativo mixto

C Por déficit atencional

D Esquizoafectivo

E Delirante

Respuesta A. Diagnóstico: Bipolar (opción A). Tiene una manía clásica, secundaria al uso de fármacos y, por tanto, tiene un TAB. El trastorno bipolar es una enfermedad genética (herencia autosómica dominante) con alta prevalencia de antecedentes familiares, que debuta típicamente entre los 18 y 30 años.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 128

Un paciente de 19 años, estudiante universitario, inicia sertralina oral, debido a un trastorno de ansiedad social. Evoluciona con verborrea e hiperactividad, le habla a personas con las que normalmente no conversaba y se muestra muy inquieto y optimista. No se observa cansado, a pesar de dormir poco. Como antecedente, tuvo una depresión diagnosticada a los 18 años, que respondió al tratamiento antidepresivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno bipolar
B Trastorno esquizoafectivo
C Trastorno esquizotípico de la personalidad
D Distima
E Trastorno por déficit atencional

Respuesta A. Diagnóstico: Trastorno bipolar (opción A). Tiene una manía aguda, por lo que tiene un trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad genética (herencia autosómica dominante) con alta prevalencia de antecedentes familiares, que debuta típicamente entre los 18 y 30 años.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 35

Paciente femenina con antecedente de episodio depresivo mayor hace 5 años tratada, nuevamente sintomática, parte antidepresivos y evoluciona con cambios de conducta aumento de energía: a. Bipolar

A Trastorno de ansiedad generalizada
B Trastorno obsesivo compulsivo
C Trastorno de estrés postraumático
D Episodio depresivo mayor
E Trastorno bipolar

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Trastorno de ansiedad generalizada (opción A). Intoxicación por litio: vómitos, temblor, ataxia, poliuria; manejo con suero fisiológico y hemodiálisis si grave.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 178

Una paciente de 23 años, en tratamiento antidepresivo, desde hace 15 días, consul- ta por un cuadro paranoide, asociado a expansividad. Además presenta disminución de los requerimientos de sueño, irritabilidad, agresividad y aumento de la actividad psico- motora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Acatisia
B Esquizofrenia
C Depresión psicótica
D Trastorno bipolar
E Trastorno de personalidad limítrofe

Respuesta D. Diagnóstico: Trastorno bipolar (opción D). Es una manía aguda, en contexto del uso de antidepresivos. Por tanto es un tras- torno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad genética (herencia autosómica dominante) con alta prevalencia de antecedentes familiares, que debuta típicamente entre los 18 y 30 años.

▶ VER CLASE 5.01.1.010 Esquizofrenia y otros trastornos psicòticos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Psiquiatría 17.10 · Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES
Psiquiatría 17.11 · Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma
Psiquiatría 17.12 · Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve

QUÉ HAY QUE SABER

- Esquizofrenia: ≥2 síntomas por 1 mes (uno debe ser delirio, alucinación o habla desorganizada; además conducta desorganizada/catatonía o síntomas negativos), con deterioro sociolaboral y duración total ≥6 meses. Prevalencia ~1%; inicio en adulto joven.
- Psicosis breve: <1 mes con recuperación completa (a menudo tras estresor); esquizofreniforme: 1–6 meses; trastorno delirante: delirio no bizarro ≥1 mes con funcionamiento conservado; psicosis puerperal: emergencia.
- Primer episodio: descartar causa orgánica o tóxica (drogas en orina, TAC/RM, TSH, VDRL, VIH, hemograma, electrolitos; punción lumbar si hay fiebre o signos meníngeos). El cannabis en adolescentes aumenta el riesgo 2–4 veces.
- Manejo inicial: notificar GES de primer episodio (desde 15 años; confirmación por psiquiatra en 20 días y tratamiento en 24 horas desde la confirmación), iniciar antipsicótico atípico (risperidona 2–6 mg u olanzapina 10–20 mg) y derivar.
- Vigilar efectos adversos: distonía aguda (biperideno), acatisia (propranolol), parkinsonismo, síndrome metabólico (peso, PA, glicemia y lípidos basal, 1 y 3 meses y anual).
- Seguimiento: derivar a psiquiatría; mantener antipsicótico 1–2 años tras un primer episodio; refractaria (falla de 2 antipsicóticos) va a clozapina.

PREGUNTAS · 36

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 38

Un paciente de 18 años, adicto a la pasta base, presenta un episodio psicótico, en relación al consumo, el que es manejado con haloperidol intramuscular. Al día siguiente presenta contracción tónica del cuello, que desvía la cabeza hacia la izquierda, con intenso dolor. **El diagnóstico más probable es:**

A Distonía aguda
B Acatisia
C Síndrome neuroléptico maligno
D Disquinesia tardía
E Parkinsonismo farmacológico

Respuesta A. Contracción tónica y dolorosa del cuello dentro de las 24–48 horas tras haloperidol: distonía aguda (tortícolis). Se trata con biperideno IM o EV.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 109

Paciente en tratamiento con flufenazina, presenta alteración de conciencia, fiebre, rigidez de extremidades y taquicardia. **¿Diagnóstico más probable?**

A Hipertermia maligna anestésica
B Síndrome serotoninérgico
C Crisis distónica aguda
D Síndrome neuroléptico maligno
E Encefalitis autoinmune

Respuesta D. Neuroléptico + fiebre + rigidez de extremidades + compromiso de conciencia + taquicardia: síndrome neuroléptico maligno. La distonía aguda es focal, sin fiebre, sin rigidez generalizada y con conciencia conservada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 39

Joven de 22 años que abandonó su carrera universitaria hace 8 meses, pasa la mayor parte del tiempo en casa, habla solo, ríe sin motivo aparente y cree que sus compañeros lo persiguen. Sin consumo de sustancias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Esquizofrenia
B Trastorno esquizoafectivo
C Trastorno de personalidad esquizoide
D Trastorno bipolar con psicosis
E Trastorno delirante crónico

Respuesta A. Esquizofrenia: síntomas positivos (alucinaciones, ideas de persecución), negativos (aislamiento social, abandono de actividades) y desorganización (habla solo, risa inapropiada) por más de 6 meses en un adulto joven. Requiere antipsicótico y rehabilitación.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 76

Una paciente de 40 años, trabajadora de supermercado, consulta por sentirse angustiada y triste. Refiere que desde su adolescencia presenta alucinaciones auditivas, consistentes en voces que hacen comentarios negativos acerca de ella, las que desaparecen durante algunos periodos, reapareciendo en momentos de mayor estrés o soledad. Refiere que en el último tiempo las voces le han estado ordenando que se suicide. Al examen físico destaca su aspecto personal muy descuidado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trastorno delirante crónico
B Delirium
C Esquizofrenia
D Trastorno de personalidad paranoide
E Depresión mayor con síntomas psicóticos

Respuesta C. Es una esquizofrenia clásica, con alucinaciones auditivas, inicio en la adolescencia y afectación general de su vida (aspecto descuidado), complicada con una probable depresión y síntomas ansiosos. No parece un trastorno esquizoafectivo, ya que no tiene historia de episodios depresivos o maníacos repetidos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 74

Un paciente de 18 años presenta un cuadro de ánimo bajo, en tratamiento con antidepresivos por 3 meses, sin respuesta. Sus padres están muy preocupados, porque permanece encerrado en su cuarto, sin hacer nada, ni siquiera ver televisión. Al examinarlo, no se aprecia anhedonia, ni tristeza. No ha tenido alucinaciones. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A Distimia
B Trastorno de personalidad esquizoide
C Esquizofrenia
D Trastorno esquizoafectivo
E Depresión mayor

Respuesta C. Aunque no tenga delirios ni alucinaciones, parece una esquizofrenia que está debutando, probablemente de predominio negativo (esquizofrenia simple) o incluso catatónica, por permanecer inmóvil tanto tiempo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 13

Un paciente con esquizofrenia, recién diagnosticado, inicia tratamiento con risperidona 2 mg/día hace 5 días. Al tercer día, inicia un cuadro de disestesias en las extremidades inferiores, asociadas a angustia, inquietud y cambio continuo de posición. Se muestra muy incómodo y angustiado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trastorno de adaptación
B Distonía aguda
C Disquinesia aguda
D Acatisia
E Hipomanía

Respuesta D. Acatisia: inquietud con malestar en las piernas y necesidad de cambiar de posición, a los pocos días de iniciar risperidona.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 90

Un paciente de 35 años está convencido que las vacunas contra la Covid-19 contienen un chip para rastrear a las personas y que hay un acuerdo entre Bill Gates y muchos de los gobiernos para controlar las mentes de la población, tal como lo ha hecho con muchas personas, a las que califica de «borregos». Cree que la mayoría de los médicos son parte de este complot, porque están financiados por las farmacéuticas y el Gobierno. Si bien se desenvuelve normalmente en su trabajo, ha tenido varios problemas con compañeros de trabajo y con sus familiares, cuando se toca el tema de las vacunas, en el que habla con gran vehemencia y certeza, criticando duramente a quienes le recomiendan vacunarse. También pierde mucho tiempo discutiendo sobre el tema en redes sociales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Esquizofrenia
B Trastorno delirante
C Trastorno del espectro autista en el adulto
D Trastorno bipolar
E Trastorno de personalidad paranoide

Respuesta B. Trastorno delirante clásico, con un delirio sistematizado y afectación únicamente en esa área. No tiene alucinaciones ni síntomas negativos o primarios de esquizofrenia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 108

Un paciente de 54 años está seguro de que su esposa lo engaña, lo que confirma con un cambio de actitud que ella ha tenido en el último tiempo. Además cree saber con quién lo engaña, ya que se ha encontrado con el sujeto en la calle y siempre mira para abajo. La esposa y los familiares niegan los hechos, pero están preocupados por lo que pasa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trastorno de personalidad esquizoide
B Esquizofrenia
C Trastorno obsesivo compulsivo
D Trastorno delirante crónico
E Trastorno bipolar

Respuesta D. Es un trastorno delirante crónico clásico, con delirio de celos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 17

Una mujer de 35 años, sin antecedentes, consulta porque está segura de que todos sus compañeros de trabajo la seducen y la acosan, esto le ocurre desde hace aproximadamente 10 años y le ha traído problemas en su trabajo, por lo que ha sido despedida en otros trabajos. No refiere presentar problemas en otros ámbitos de su vida, tiene buena relación con familiares y amigos. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A Trastorno de personalidad paranoide
B Trastorno de personalidad histriónico
C Trastorno delirante crónico
D Trastorno bipolar
E Trastorno de la personalidad esquizotípico

Respuesta C. Si bien parece histriónica, ha perdido el juicio de realidad y además «está segura», por lo que es un trastorno delirante crónico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 95

Una paciente de 81 años, hace un año tiene la idea de padecer de VIH, por lo que se ha realizado múltiples exámenes, los que siempre han resultado negativo. A pesar de ello, ella continúa con la idea. Fuera de esto, su vida no ha sido mayormente afectada. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A Demencia
B Trastorno obsesivo compulsivo
C Trastorno delirante crónico
D Trastorno por hipocondría
E Depresión psicótica

Respuesta C. Trastorno delirante crónico clásico, con delirio de enfermedad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 71

Una paciente de 46 años presenta conflictos frecuentes con distintas administraciones de su edificio, que se han extendido durante los últimos 10 años, y que ella atribuye al hecho de que vive sola y que, durante su jornada laboral, los conserjes y el personal del edificio aprovechan su ausencia para entrar a su departamento y utilizarlo como lugar de alimentación y para dormir y descansar en él sin su autorización. Comenta que las cámaras del edificio no han logrado captar estos hechos debido a la probable utilización de algún tipo de inhibidor de señal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Esquizofrenia

B Depresión con síntomas psicóticos

C Trastorno delirante crónico

D Trastorno de personalidad paranoide

E Trastorno de personalidad esquizoide

Respuesta C. Tiene un delirio: ideas fuera de la realidad, de certeza absoluta, sistematizadas y crónicas. Es un trastorno delirante crónico clásico. No es un trastorno de personalidad paranoide, que es una persona muy desconfiada y celosa, pero sin pérdida del juicio de realidad.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un joven de 20 años es llevado a la consulta médica por sus padres debido a que en los últimos 7 meses ha abandonado la universidad, se aísla en su habitación y afirma que una organización criminal lo espía a través de la televisión. En el examen mental se constata afecto aplanado, soliloquios y alucinaciones auditivas de voces que comentan lo que hace. El examen físico y el screening de drogas en orina son normales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y la conducta médico-legal más adecuada? **¿Cuál es el diagnóstico clínico y la conducta médico-legal más adecuada?**

A Trastorno delirante crónico; manejo ambulatorio exclusivo en APS sin derivación

B Primer episodio de esquizofrenia; activar GES 34, iniciar antipsicótico atípico y derivar a confirmación por especialista

C Trastorno esquizoafectivo; indicar sertralina 100 mg y reposo en casa

D Psicosis reactiva breve; esperar resolución espontánea antes de cumplir el mes

E Trastorno de personalidad esquizotípico; indicar psicoterapia individual sin fármacos

Respuesta B. Cumple criterios de esquizofrenia: síntomas positivos (delirio de persecución, voces comentadoras), negativos (aplanamiento, abulia) y disfunción sociolaboral de más de 6 meses, con tóxicos negativos. En Chile es un primer episodio de esquizofrenia cubierto por GES 34: confirmación por psiquiatra en 20 días como máximo y tratamiento integral dentro de 24 horas desde la confirmación. Se notifica, se inicia un atípico (por ejemplo risperidona u olanzapina) y se deriva. La psicosis breve dura menos de un mes.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un comerciante de 38 años sin antecedentes psiquiátricos pierde su local comercial en un incendio intencional. A los dos días comienza con agitación psicomotora, insomnio total, llanto incontrolable y afirmaciones de que «ve demonios que le ordenan caminar en círculos». Es hospitalizado y tratado transitoriamente con dosis bajas de risperidona. Al día 18 del cuadro, los síntomas psicóticos desaparecen por completo, encontrándose orientado, reflexivo y reincorporándose plenamente a sus actividades comerciales. ¿Cuál es el diagnóstico retrospectivo definitivo? **¿Cuál es el diagnóstico retrospectivo definitivo?**

A Esquizofrenia hebefrénica

B Trastorno psicótico breve con desencadenante grave

C Trastorno esquizofreniforme residual

D Trastorno de personalidad límite

E Trastorno bipolar en manía pura

Respuesta B. Inicio brusco tras un estresor biográfico masivo, síntomas psicóticos floridos y resolución completa con restitución ad integrum a los 18 días, es decir, en menos de 1 mes: trastorno psicótico breve con desencadenante grave (antes psicosis reactiva breve). El esquizofreniforme requiere entre 1 y 6 meses, y la esquizofrenia al menos 6 meses.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 30 años, al décimo día de su primer parto, es traída por su familia. Lleva 3 noches casi sin dormir, está agitada y confusa, cambia rápido del llanto a la euforia y dice que su hijo "está poseído y hay que salvarlo". La familia teme que lo lastime. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tranquilizar, indicar apoyo familiar y control en 2 semanas

B Iniciar sertralina y control ambulatorio

C Indicar benzodiacepinas y enviarla a casa con su familia

D Hospitalización psiquiátrica urgente, con supervisión y protección del bebé

E Aplicar la escala de Edimburgo y decidir según el puntaje

Respuesta D. Es una psicosis puerperal: inicio hiperagudo, insomnio, agitación, labilidad y delirios centrados en el bebé. Es una emergencia con riesgo de infanticidio y suicidio. Se hospitaliza de inmediato y se trata con antipsicótico y estabilizador.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 24 años con esquizofrenia, en tratamiento con risperidona 4 mg al día hace 3 meses con buena adherencia. Los delirios de persecución y las voces desaparecieron, pero sigue sin estudiar ni trabajar, con afecto plano, habla escasa y sin interés en nada. No tiene temblor, rigidez ni inquietud. Su pareja pide aumentar la dosis «hasta que se active». **¿Cuál es la explicación y la conducta más adecuada?**

A Resistencia al tratamiento; subir risperidona a 12 mg al día

B Síntomas negativos de hipoactividad mesocortical, que responden poco al fármaco; mantener el tratamiento y reforzar rehabilitación psicosocial

C Depresión mayor; suspender el antipsicótico e iniciar un antidepresivo solo

D Parkinsonismo farmacológico; agregar biperideno de forma indefinida

E Recaída psicótica; hospitalizar de inmediato

Respuesta B. Remitieron los síntomas positivos (vía mesolímbica bloqueada), y lo que persiste es negativo y cognitivo (hipoactividad mesocortical), que responde poco a los antipsicóticos. Subir la dosis, en el caso de la risperidona sobre 6 mg, solo aumenta los efectos extrapiramidales y la prolactina. Se mantiene el tratamiento y se refuerza la rehabilitación psicosocial.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 29 años con esquizofrenia refractaria, en el día 18 de clozapina 150 mg al día. Consulta por fiebre de 38,2 °C, dolor precordial, disnea y taquicardia de 125 por minuto persistente en reposo. Su hemograma de control de la semana anterior fue normal, con RAN de 3.500/mm³. El electrocardiograma muestra taquicardia sinusal con alteraciones inespecíficas del ST. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Atribuirlo a ansiedad e indicar una benzodiacepina

B Sospechar miocarditis por clozapina: suspender el fármaco y estudiar con troponinas y ecocardiograma

C Reducir la clozapina a la mitad y controlar en una semana

D Descartar agranulocitosis por hemograma normal y continuar igual

E Agregar ácido valproico por riesgo de convulsiones

Respuesta B. Fiebre, disnea, dolor precordial y taquicardia persistente no explicada en el primer mes de clozapina son una miocarditis hasta demostrar lo contrario. Se estudia con ECG, troponinas y ecocardiograma y se suspende el fármaco. El hemograma normal descarta agranulocitosis, pero no esta complicación.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 28 años con esquizofrenia ha recibido tratamiento con haloperidol 10 mg/día durante 8 semanas y posteriormente con risperidona 6 mg/día durante 8 semanas, ambas con adherencia confirmada por sus cuidadores, persistiendo con alucinaciones auditivas agresivas e ideación delirante severa que le impiden salir a la calle. Su hemograma basal muestra leucocitos 6.500/mm³ con neutrófilos en 4.200/mm³. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y el tratamiento farmacológico de elección? **¿Cuál es el diagnóstico clínico y el tratamiento farmacológico de elección?**

A Psicosis reactiva; suspender antipsicóticos e iniciar psicoterapia

B Esquizofrenia refractaria; iniciar tratamiento con clozapina bajo protocolo de monitorización hematológica

C Trastorno bipolar maníaco; iniciar monoterapia con carbamazepina

D Simulación de síntomas; dar el alta sin medicación

E Esquizofrenia simple; rotar a clorpromazina en dosis bajas

Respuesta B. Cumple criterios de esquizofrenia refractaria: falla a dos antipsicóticos distintos a dosis plena por al menos 6 semanas cada uno, uno de ellos atípico (risperidona), con adherencia confirmada. Su hemograma basal es normal (leucocitos mayores de 3.500 y RAN mayor de 2.000), por lo que se inicia clozapina bajo el protocolo de farmacovigilancia hematológica (hemograma semanal los primeros 6 meses).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 47 años, ingeniero con buen desempeño, es traído por su hermana. Desde hace un año está convencido de que su esposa le es infiel con un compañero de gimnasio: revisa su teléfono, la sigue y la ha amenazado con «terminar con esto». Está bien vestido, es coherente y colaborador; niega escuchar voces, su ánimo es estable y se concentra sin problemas en su trabajo. La esposa teme por su seguridad. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?**

A Esquizofrenia paranoide; hospitalizar de inmediato por falta de crítica

B Trastorno delirante celotípico; evaluar riesgo de violencia hacia la pareja, indicar un antipsicótico atípico, no confrontar el delirio y derivar a psiquiatría

C Trastorno de personalidad paranoide; terapia de pareja y alta

D Trastorno psicótico breve; observar el cuadro por unos días

E Celos normales; confrontar con pruebas para que reconozca su error

Respuesta B. Delirio sistematizado no bizarro de más de 1 mes, sin alucinaciones, desorganización ni síntomas negativos, con funcionamiento conservado: trastorno delirante, subtipo celotípico (síndrome de Otelo). Tiene riesgo alto de violencia hacia la pareja, por lo que se evalúa la seguridad. Se usa un antipsicótico atípico, se mantiene una actitud empática sin confrontar ni validar el delirio, y se deriva.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 137

Un paciente de 26 años, estudiante universitario con regular rendimiento, es traído por sus padres porque desde hace tres meses no ha asistido a clases, ya que prefiere quedarse en su habitación. Ellos refieren que siempre fue solitario y que no buscaba tener amistades. Al entrevistarlo de forma dirigida se ríe sin motivo y refiere que no quiere salir de su habitación porque la voz del diablo lo amenaza. El diagnóstico más probable es:

A Trastorno delirante crónico
B Trastorno de la personalidad esquizoide
C Delirium
D Esquizofrenia hebefrénica
E Trastorno Bipolar

Respuesta D. Diagnóstico: Esquizofrenia hebefrénica (opción D). La risa sin motivo orienta a Hebefrenia. El cuadro clínico es sugerente de EQZ.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 116

Un paciente de 21 años, abandonó a los 18 años su hogar, viviendo solo en la calle. Tiene la idea de ser un enviado de Dios, con la misión de salvar al mundo y dice que los ángeles le susurran al oído diciéndole cómo hacerlo. Los familiares refieren que empezó hace 3 años con esto y que no ha cambiado mucho desde entonces. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno delirante crónico
B Esquizofrenia
C Trastorno bipolar
D Trastorno de personalidad esquizoide
E Trastorno de conducta

Respuesta B. Diagnóstico: Esquizofrenia (opción B). Es una EQZ clásica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 129

Un hombre de 18 años tiene la idea de que algunas personas quieren dañarlo. Pre- viamente a esto presentaba retraimiento social. En el último tiempo el cuadro empeora, agregándose alucinaciones de voces, que lo insultan y ha descuidado significativamente su higiene personal. El diagnóstico más probable es:

A Esquizofrenia
B Personalidad esquizotípica
C Trastorno delirante crónico
D Trastorno esquizoafectivo
E Depresión psicótica

Respuesta A. Diagnóstico: Esquizofrenia (opción A). Es una esquizofrenia clásica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 95

Una paciente de 42 años, que 2 meses después de un quiebre conyugal, evoluciona con un cuadro de delirio de persecución y alucinaciones auditivas, asociado a marcada tristeza, anhedonia, irritabilidad y culpa patológica. Como antecedentes psiquiátricos, ella sufrió una depresión postparto y uno de sus tíos está en tratamiento con litio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Depresión psicótica
B Trastorno adaptativo mixto
C Trastorno esquizoafectivo
D Esquizofrenia
E Trastorno esquizoide

Respuesta C. Tiene clara coexistencia de síntomas psicóticos (alucinaciones y delirio) con síntomas anímicos depresivos, por lo que es un T. esquizoafectivo clásico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 39

Un paciente de 52 años presenta un cuadro de alucinaciones auditivas, desde la adolescencia. En el último tiempo, las alucinaciones se intensifican, escuchando voces que la insultaban y le decían que se suicidara. Está muy angustiada y se ha sentido triste por lo que le sucede. El diagnóstico más probable es:

A Esquizofrenia
B Trastorno delirante crónico
C Trastorno esquizoafectivo
D Trastorno depresivo mayor
E Trastorno esquizotípico de la personalidad

Respuesta A. Diagnóstico: Esquizofrenia (opción A). Parece una esquizofrenia por las alucinaciones auditivas y el inicio en la adolescencia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 172

Un paciente masculino, de 22 años, desde hace más de 6 meses ha dejado de compartir con su familia y casi no sale de su pieza. Además, ha descuidando su aspecto personal. Sus familiares refieren que en ocasiones lo escuchan musitar, hablar y reírse solo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Ezquizofrenia
B Depresión psicótica
C Trastorno delirante crónico
D Trastorno de personalidad esquizoide
E Trastorno bipolar

Respuesta A. Es una forma clásica del primer brote de esquizofrenia. La edad es compatible. Seguramente tiene alucinaciones auditivas y por eso habla y se ríe solo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 75

Un paciente de 24 años tiene la idea de que es el enviado de Dios y que está encargado de la salvación de las almas. Se muestra convencido de ello y al confrontarlo con la realidad, reacciona algo agresivo. Es un paciente tranquilo, con pocos amigos y afectivamente plano. El diagnóstico más probable es:

A Trastorno esquizoafectivo
B Trastorno bipolar
C Trastorno delirante crónico
D Trastorno de personalidad narcisista
E Esquizofrenia

Respuesta E. Diagnóstico: Esquizofrenia (opción E). Tiene síntomas positivos (delirio megalomaniaco) y negativos (aplanamiento afectivo). Es una Esquizofrenia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 51

Paciente joven de 24 años, es traído por sus padres ya que desde hace aproximadamente un año se vuelve muy solitario, no sale de su hogar, descuida su higiene y habla frecuentemente sobre el apocalipsis y el fin de la humanidad. Al entrevistarlo se aprecia con marcado aplanamiento afectivo y frente a distintas preguntas habla sobre el apocalipsis. Su madre está actualmente cursando con depresión y su padre tiene trastorno bipolar en tratamiento con litio. El diagnóstico más probable es:

A Trastorno bipolar
B Trastorno por abuso de sustancias
C Trastorno de la personalidad esquizotípico
D Esquizofrenia
E Trastorno delirante crónico

Respuesta D. Es una familia muy disfuncional. La clínica orienta mucho a EQZ. Los antecedentes familiares confunden, porque orientan a T. bipolar, pero no hay clínica de dicha enfermedad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 135

Paciente con trabajo y buenas relaciones, pero cree que sus vecinos entran a su casa mientras ella no está. ¿Diagnóstico más probable?

A Esquizofrenia paranoide
B Trastorno delirante
C Trastorno esquizoafectivo
D Trastorno de personalidad paranoide
E Trastorno bipolar con síntomas psicóticos

Respuesta B. Diagnóstico: Trastorno delirante (opción B). Trastorno delirante.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 69

Un paciente de 84 años consulta por un cuadro de 4 semanas de evolución de des- confianza, asociada a enojo porque quienes viven con él le roban y le cambian sus co- sas de lugar, para molestarlo. Hace 1 semana despidió a alguien que había trabajado por 30 años con él, por la misma razón. Al examen se muestra molesto respecto al tema, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Demencia
B Paranoia
C Delirium
D Trastorno delirante
E Depresión psicótica

Respuesta D. Cumple criterios de trastorno delirante, con delirio de persecución. No se indicaba desorientación ni inatención, como para pensar en delirium; tampoco había síntomas anímicos, como para pensar en depresión. La memoria no estaba afectada, como para pensar en demencia. No es un trastorno delirante crónico (mayor a 3 meses).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 78

Un hombre de 25 años, con antecedente de esquizofrenia, con mala adherencia al tratamiento oral, inicia tratamiento con flufenazina intramuscular de depósito hace 3 días. Sin embargo, comienza con un cuadro de inquietud, malestar general y fiebre hasta 38,7°C, seguido de obnubilación. Al examen físico tiene FC: 109x', PA: 150/102 mmHg, T°: 38,5°C y, en el examen segmentario, destaca rigidez muscular generalizada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Meningitis bacteriana
B Distonía aguda
C Infección en el sitio de punción
D Síndrome serotoninérgico
E Síndrome neuroléptico maligno

Respuesta B. Diagnóstico: Distonía aguda (opción B).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 91

Una niña de 15 años ha presentado una serie de conflictos con sus familiares en el último tiempo, discutiendo con varios de ellos, de manera intensa. Además, está muy conversadora, incluso con extraños y ha tenido varios problemas en el colegio, debido a que interrumpe reiteradamente las clases y, cuando sus profesores la han hecho callar, responde de forma agresiva y los insulta. Duerme cerca de 5 horas al día, inició su vida sexual recientemente, sin protección y ha consumido marihuana en 3 oportunidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno por déficit atencional hiperactivo
B Trastorno de personalidad limítrofe
C Esquizofrenia
D Trastorno bipolar
E Trastorno por consumo de sustancias

Respuesta C. Diagnóstico: Esquizofrenia (opción C).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 83

Una paciente de 64 años ha presentado, desde hace algún tiempo, conflictos con sus vecinos. Refiere que varios de sus vecinos tienen intenciones de dañarla o perjudicarla de alguna forma. Además, refiere la certeza de que sus vecinos han entrado a su departamento, habiéndose sentado en sus sillones, fumado en su sala e incluso dormido en su cama. Tiene una red de apoyo funcional, con buenas relaciones con sus familiares, quienes se muestran preocupados con este tema. No tiene otros síntomas y su examen de Minimental resulta 29/30. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno delirante
B Depresión con síntomas psicótico
C Esquizofrenia de inicio tardío
D Trastorno de personalidad paranoide
E Trastorno esquiafectivo

Respuesta B. Diagnóstico: Depresión con síntomas psicótico (opción B). Ánimo bajo persistente por más de dos semanas, anhedonia, alteraciones del sueño y fatiga cumplen criterios diagnósticos para episodio depresivo mayor (Garantía GES en APS). El tratamiento de primera línea incluye psicoterapia e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS como sertralina).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 76

Un paciente de 56 años dice, desde hace algunos meses, que sus vecinos lo espían y que están conspirando contra él. No tiene otros problemas y tiene una vida laboral y familiar normales. La esposa se muestra muy preocupada y refiere además que el paciente es aceptado y querido por todos y que los vecinos nunca lo han espiado ni nada similar. El diagnóstico más probable es:

A Esquizofrenia
B Depresión
C Trastorno delirante crónico
D Trastorno de personalidad paranoide
E Trastorno obsesivo compulsivo

Respuesta C. Diagnóstico: Trastorno delirante crónico (opción C). Cuadro clásico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 171

Un hombre de 50 años asegura que es constantemente espiado por los gobiernos de varios países, dado que el maneja información importante y confidencial de muchos políticos y personas de poder. Al preguntarle cómo sabe que lo espían, reacciona enojado diciendo que es obvio y que uno de sus vecinos fue quien inició todo esto. El diagnóstico más probable es:

A Esquizofrenia
B Trastorno delirante
C Trastorno esquizoafectivo
D Trastorno esquizoide de la personalidad
E Trastorno paranoide de la personalidad

Respuesta B. Tiene un delirio paranoide, con la reacción apodíptica clásica de alguien psicótico. La edad y la ausencia de alucinaciones y síntomas negativos hacen improbable una esquizofrenia. No tiene síntomas anímicos, como para pensar en T. esquizoafectivo. Los T. personalidad no están psicóticos, aunque el TP paranoide es muy celoso y desconfiado y el TP esquizoide es muy solitario, apático e indiferente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 83

Un hombre de 46 años refiere que las mujeres de su trabajo se le insinúan y quieren tener una relación con él. Sin embargo, no hay testigos de esos hechos y al interrogar a sus compañeras de trabajo, lo niegan. Al confrontar al paciente, se enoja, ya que le molesta que no crean en lo que él dice. El diagnóstico más probable es:

A Hipomanía
B Esquizofrenia
C Trastorno delirante crónico
D Dismorfofobia
E Trastorno de personalidad narcisista

Respuesta C. Diagnóstico: Trastorno delirante crónico (opción C). Es un trastorno delirante crónico de libro (delirio sistematizado; pérdida de juicio de realidad).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 109

Una paciente de 58 años ha tenido gran conflicto con la comunidad del edificio en que vive y también con la administración. Además, se la ha visto vociferando en los pasillos. Ella refiere que existe una asociación ilícita para explotar personas, en la que estarían involucrados el conserje, el administrador y varios de los copropietarios del edificio. Fuera de eso, no hay mayor afectación y se desenvuelve normalmente en su trabajo. Los familiares niegan las acusaciones. Al ser consultada dirigidamente, ella refiere el antecedente de consumir marihuana alrededor de una vez al mes. El diagnóstico más probable es:

A Depresión psicótica
B Trastorno delirante crónico
C Esquizofrenia
D Psicosis inducida por drogas
E Trastorno bipolar

Respuesta B. Diagnóstico: Trastorno delirante crónico (opción B). Tiene un TDC, con delirio paranoide.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 110

Una paciente de 42 años, que 2 meses después de una separación conyugal, evoluciona con un cuadro de delirio paranoide y alucinaciones auditivas. Además presenta marcada tristeza, anhedonia, irritabilidad y culpa patológica. Como antecedentes psiquiátricos, ella sufrió una depresión postparto y uno de sus tíos está en tratamiento con litio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Depresión psicótica
B Trastorno bipolar
C Trastorno esquizoafectivo
D Esquizofrenia
E Trastorno esquizoide de la personalidad

Respuesta D. Hay una mezcla de síntomas psicóticos (delirio paranoide y alucinaciones auditivas) con un síndrome afectivo completo (tristeza, anhedonia, culpa), sin predominio claro de uno de ellos, lo que orienta a un trastorno esquizoafectivo. La depresión psicótica y el trastorno bipolar explican los síntomas psicóticos solo durante el episodio anímico, y la esquizofrenia no incluye un síndrome afectivo de esta magnitud.

▶ VER CLASE `5.01.1.011` **Consumo perjudicial de alcohol y drogas** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.16 · Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

QUÉ HAY QUE SABER

- Consumo perjudicial: patrón de uso de alcohol o drogas que ya causa daño físico, mental o social (gastritis, accidentes, conflictos, conducción en estado de ebriedad) sin criterios de dependencia (sin tolerancia, abstinencia ni pérdida de control marcada).
- Pesquisa en APS con AUDIT (alcohol) o ASSIST (otras sustancias): AUDIT 0–7 bajo riesgo, 8–15 consumo de riesgo, 16–19 perjudicial, ≥20 probable dependencia; complementar con GGT/VCM y evaluación clínica.
- Tratamiento: intervención breve con entrevista motivacional según la etapa de cambio (precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantención), sin confrontar; metas concretas de reducción o abstinencia.
- No corresponde iniciar disulfiram ni benzodiacepinas; tratar comorbilidad (depresión, ansiedad) y daño orgánico, y pesquisar otras sustancias.
- Seguimiento completo: controles programados para reforzar metas y registrar consumo; derivar a programa especializado si progresa a dependencia o fracasa la intervención breve.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 73

Una paciente de 35 años es traída al servicio de urgencia debido a que, luego del consumo de alcohol en una fiesta, presentó una actitud agresiva peleando con otros invitados, a quienes arrojó vasos de vidrio, por lo que fue retirada del lugar. Refiere que consume alcohol de manera esporádica, habitualmente solo durante los fines de semana, y que lo hace como una forma de distenderse de su alta carga laboral. En una oportunidad fue detenida por manejar en estado de ebriedad, sin embargo, ella no considera que ello sea un problema. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Iniciar disulfiram vía oral

B Indicar benzodiacepinas vía oral

C Iniciar bupropión vía oral

D Realizar entrevista mo2vacional

E Derivar para psicoterapia cogni2vo-conductual

Respuesta D. La paciente tiene consumo perjudicial de alcohol con escasa conciencia del problema, es decir, está en etapa precontemplativa, por lo que primero se debe trabajar la motivación al cambio con entrevista motivacional. Los fármacos y la psicoterapia no sirven si no hay intención de cambiar, y las benzodiacepinas no están indicadas sin síndrome de abstinencia.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 34 años consulta por epigastralgia. Bebe casi todos los fines de semana, 8 a 10 tragos por ocasión, y hace 3 meses fue detenido por conducir bajo la influencia del alcohol. Niega temblor matinal, beber al despertar o intentos fallidos de dejarlo. Reconoce que 'debería tomar menos'. El AUDIT da 17 puntos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar disulfiram 250 mg al día

B Intervención breve con entrevista motivacional, metas de reducción y controles de seguimiento en APS

C Indicar naltrexona y control en 6 meses

D Hospitalizar para desintoxicación con diazepam

E Tranquilizar, ya que solo bebe los fines de semana

Respuesta B. AUDIT 16–19 con daño ya presente y sin tolerancia ni abstinencia corresponde a consumo perjudicial. El paciente está en etapa contemplativa: se trata con intervención breve y entrevista motivacional, metas concretas y seguimiento. No requiere desintoxicación ni fármacos de deshabituación, y minimizarlo es un error.

▶ VER CLASE 5.01.1.012 **Dependencia de alcohol** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.15 · Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

QUÉ HAY QUE SABER

- Dependencia de alcohol: tolerancia, abstinencia, consumo mayor al planeado, deseo persistente o fracaso al reducir, tiempo dedicado al consumo, abandono de actividades y persistencia pese al daño. Pesquisa con AUDIT (≥20 probable dependencia).
- Abstinencia: temblor y disautonomía a las 6–12 h, alucinosis con sensorio lúcido a las 12–24 h, convulsiones a las 12–48 h y delirium tremens a las 48–96 h (confusión, zoopsias, fiebre; mortalidad hasta 15%).
- Tiamina 100–300 mg EV/IM siempre antes de cualquier suero glucosado; Wernicke: oftalmoplejía, ataxia y confusión. Korsakoff: amnesia anterógrada con confabulación.
- Abstinencia según CIWA-Ar: <10 manejo ambulatorio sin benzodiacepinas; 10–19 diazepam 10–20 mg VO c/1–2 h; ≥20 hospitalizar. Lorazepam en cirróticos y ancianos. Convulsiones: benzodiacepinas, no fenitoína crónica.
- Deshabituación: entrevista motivacional y programa de tratamiento; naltrexona 50 mg/día (reduce craving; no con opioides ni hepatitis), acamprosato (seguro en daño hepático) o disulfiram 250 mg/día supervisado en paciente motivado.
- Seguimiento completo: controles para prevenir recaídas, tratar comorbilidad psiquiátrica y orgánica, apoyo familiar y grupos de autoayuda; derivar si hay complicaciones o fracaso.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 103

Paciente de 55 años alcohólico crónico, 48 horas después de dejar de beber presenta agitación severa, alucinaciones visuales de insectos, temblor generalizado, taquicardia 120 lpm, sudoración y fiebre 38°C. **¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?**

A Delirium tremens: diazepam EV + tiamina + corrección hidrolectrolítica

B Psicosis alcohólica: haloperidol

C Meningoencefalitis: antibióticos EV

D Hipoglicemia: glucosa EV en bolo

E ACV isquémico: tPA

Respuesta A. Abstinencia alcohólica grave a las 48–72 horas del cese, con hiperactividad autonómica y alucinaciones: delirium tremens. Es la única indicación de benzodiacepinas en el delirium (diazepam o lorazepam), junto con tiamina y corrección hidroelectrolítica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 72

Un paciente de 70 años, con antecedente de daño hepático crónico y consumo de alcohol activo, consulta porque quiere dejar de beber. Consume 3 litros de cerveza al día y comenta que hace un año intentó bajar el consumo a 1 litro al día, sin embargo, presentó agitación, angustia y la visualización de insectos que él no sabía que no eran reales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Indicar el cese inmediato del consumo de alcohol
B Iniciar disulfiram
C Hospitalizar para desintoxicación
D Indicar lorazepam
E Derivar para psicoterapia cogni2vo-conductual

Respuesta C. Tiene alcoholismo con consumo alto y motivación para dejar de beber, pero con antecedente de síndrome de abstinencia grave con alucinaciones (visualiza insectos), por lo que la suspensión debe hacerse con supervisión médica en el hospital. Indicar el cese inmediato en domicilio es riesgoso por la posibilidad de delirium tremens. El disulfiram no se inicia en un paciente con daño hepático, y la psicoterapia sola no resuelve el riesgo de abstinencia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 131

Paciente con hálito alcohólico en urgencias; TAC descarta lesiones. A las 48 horas, agitación y desorientación. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A Haloperidol 5 mg IM
B Tiamina 100 mg EV
C Suero glucosado 10% endovenoso
D Metadona oral
E Lorazepam endovenoso (manejo de síndrome de abstinencia alcohólica)

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Lorazepam endovenoso (manejo de síndrome de abstinencia alcohólica) (opción E). Lorazepam endovenoso (manejo de síndrome de abstinencia alcohólica).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 36

Paciente masculino con consumo OH crónico, pierde su trabajo, se fractura tobillo y se hospitaliza, pide alta voluntaria para ir a tomar cerveza, qué conducta define mejor la “adicción” x OH:

A La conducta durante la hospitalización
B Pérdida de trabajo
C Embriaguez
D La frecuencia del consumo
E Laparotomía exploratoria

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: La conducta durante la hospitalización (opción A).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 114

Un paciente alcohólico es ingresado, indicándosele tratamiento con diazepam 0,5 mg/noche y haloperidol 0,5 mg/noche. Evoluciona con sudoración, inquietud, palpita- ciones e insomnio con angustia que es mayor en la noche,

A Acatisia
B Síndrome de privación de alcohol
C Síndrome neuroléptico maligno
D Distonía aguda
E Diquinesia aguda

Respuesta B. Es un síndrome de abstinencia moderado. No tiene delirium tremens, ni convul- siones (sería severo).

▶ VER CLASE `5.01.1.013` **Dependencia de otras drogas** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.16 · Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

QUÉ HAY QUE SABER

- Dependencia de drogas (cocaína, pasta base, cannabis, benzodiacepinas, opioides): tolerancia, abstinencia, craving, pérdida de control, abandono de actividades y consumo pese al daño.
- Sospecharla ante deterioro laboral o académico, conflictos, delitos, síntomas de intoxicación o abstinencia repetidos, psicosis o complicaciones médicas (dolor torácico por cocaína, infecciones).
- Pasta base y cocaína: abstinencia con disforia, hipersomnia y craving intenso; benzodiacepinas: abstinencia con riesgo de convulsiones si se suspenden bruscamente (reinstalar diazepam o clonazepam y reducir 10–25% semanal).
- Manejo inicial: evaluar riesgo suicida, comorbilidad psiquiátrica (dual) y médica, tamizaje de VIH, hepatitis y sífilis; entrevista motivacional sin confrontar.
- Seguimiento: derivar a programa especializado de tratamiento de drogas (COSAM, programas con convenio SENDA, ambulatorio intensivo o residencial según gravedad); garantía GES en menores de 20 años con consumo de riesgo bajo a moderado.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 149

Un paciente consulta porque quiere dejar de fumar. Fuma cerca de 10 cigarrillos al día, especialmente cuando está más nervioso, los fines de semana y en las reuniones sociales. Disfruta del cigarrillo y no cree que podrá dejar de fumar sin apoyo. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este paciente?

A Terapia cognitiva conductual
B Parches de nicotina
C Bupropión
D Fluoxetina
E Vareniclina

Respuesta A. La base del tratamiento de todas las adicciones es la TCC. Además, en fumadores de menos de 15 cigarrillos al día suele ser la única intervención necesaria, ya que no suelen tener dependencia física a la nicotina. Sobre esa cantidad, a la TCC se le suele agregar sustitución con nicotina (si muchos síntomas de abstinencia) y bupropión o vareniclina (si mucho deseo de fumar).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 26 años consulta acompañado de su madre. Fuma pasta base a diario desde hace 2 años; necesita cada vez más para el mismo efecto, ha intentado dejarla 3 veces sin lograrlo, perdió su trabajo y vendió objetos de la casa. Refiere craving intenso y quiere recibir ayuda. Niega ideación suicida; examen físico normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar clonazepam diario y control en 3 meses
B Indicar disulfiram para generar aversión al consumo
C Iniciar metadona en APS
D Hospitalizar en psiquiatría en forma involuntaria
E Evaluar comorbilidad y riesgo, realizar entrevista motivacional y derivar a un programa especializado de tratamiento de drogas

Respuesta E. Tolerancia, fracaso para dejarla, abandono de actividades y craving configuran una dependencia de pasta base. El médico general sospecha, evalúa riesgo y comorbilidad, motiva y deriva a un programa especializado. No hay fármaco de sustitución para la cocaína: la metadona es para opioides y el disulfiram para alcohol; las benzodiacepinas crónicas agregan otra dependencia y no hay criterio de hospitalización involuntaria.

▶ VER CLASE 5.01.1.014 **Delirium** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.14 · Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada

QUÉ HAY QUE SABER

- Delirium: alteración aguda (horas a días) y fluctuante de la atención y la conciencia, con desorientación, desorganización del pensamiento y alucinaciones visuales; empeora de noche. Diagnóstico con CAM: inicio agudo y fluctuante + inatención + (pensamiento desorganizado o conciencia alterada).
- Formas hiperactiva, hipoactiva (la más subdiagnosticada) y mixta; factores de riesgo: edad avanzada, demencia, polifarmacia, déficit sensorial, hospitalización y cirugía.
- Buscar siempre la causa: glicemia capilar, saturación, infección (ITU, neumonía), retención urinaria, fecaloma, dolor, deshidratación, electrolitos, fármacos anticolinérgicos o benzodiacepinas, abstinencia de alcohol.
- Tratamiento: corregir la causa y medidas no farmacológicas (orientación, lentes y audífonos, luz de día, familia, evitar contención física); si hay agitación con riesgo, haloperidol 0,5–1 mg VO/IM o quetiapina 25 mg.
- Benzodiacepinas contraindicadas, salvo en abstinencia alcohólica o de benzodiacepinas.
- Seguimiento: derivar o hospitalizar según la causa; tras la resolución evaluar deterioro cognitivo de base (el delirium aumenta el riesgo de demencia).

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 168

Una paciente de 78 años con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer es hospitalizada tras desorientarse y agredir a sus cuidadores. En el examen mental se encuentra desorientada en tiempo y espacio, no puede decir los días de la semana en orden inverso y no es capaz de recordar tres palabras que se le dicen en voz alta. Dice ver a su padre en la habitación y, tras el ingreso al hospital, comienza a gritar, exigiendo que la suelten y que se quiere ir del hospital. **¿Cuál es el fármaco de elección para su manejo inicial?**

A Clonazepam
B Carbamazepina
C Haloperidol
D Mirtazapina
E Diazepam

Respuesta C. Delirium sobreimpuesto a demencia (inatención: no dice los días en orden inverso; alucinaciones visuales; agitación). Además de tratar la causa, la agitación grave se maneja con haloperidol en dosis bajas (0,5–1 mg VO o IM). Las benzodiacepinas están contraindicadas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 148

Un paciente de 56 años es encontrado inconsciente en la vía pública, con hálito alcohólico, con varios golpes. Se hospitaliza para manejo de sus lesiones, sin embargo, a las 48 horas presenta gran agitación, diciendo que lo tienen encerrado en la cárcel y no lo dejan escapar. Se observa desorientado, tembloroso y no coopera con el interrogatorio. ¿Cuál es el fármaco de elección para su manejo?

A Tiamina
B Haloperidol
C Lorazepam
D Clorpromazina
E Risperidona

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Tiamina (opción A). Tratamiento demencia: multidisciplinario + evitar estrés del cuidador + donepesilo (inhibidor acetilcolinesterasa, de elección) o memantina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 24

Un paciente de 77 años con enfermedad de Alzheimer inicial, en tratamiento con donepezilo 10 mg durante el día y trazodona 50 mg por la noche, presenta dos semanas de agitación nocturna asociada a la idea de que le están robando. Esto ha generado conflictos con sus cuidadores y, además, no ha permitido que lo bañen. Desde hace dos días presenta alucinaciones visuales. El resto de su examen físico es normal y su examen neurológico no tiene signos focales. Además de realizar exámenes, en busca de un foco infeccioso, ¿qué fármaco es de elección para su manejo actual?

A Diazepam
B Haloperidol
C Lorazepam
D Risperidona
E Amitrip2lina

Respuesta B. Pregunta difícil y discutible. Claramente Gene un delirium y hay que darle un antipsicótico. El clásico que se ha usado siempre es el haloperidol, pero los antipsicóticos atípicos, como la risperidona, cuentan con buena evidencia y seguridad. En Parkinson y demencia por cuerpos de Lewy, se contraindica el haloperidol e incluso la risperidona por el riesgo de síntomas extrapiramidales y la respuesta suele ser quetiapina. En otras demencias, como la enfermedad de Alzheimer, es discutible, pero...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 37

Un paciente se hospitaliza hace 48 horas, por un traumatismo, secundario a un accidente de tránsito. Como antecedente, toma 1 botella de vino al día, sin llegar a la ebriedad. Al segundo día de ingreso presenta un cuadro de agitación psicomotora, desorientación temporoespacial, temblor y alucinaciones visuales zoomórficas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A Haloperidol
B Lorazepam
C Risperidona
D Carbamacepina
E Tiamina

Respuesta B. Tiene un delirium tremens clásico, que se trata con benzodiacepinas, en especial el diazepam. El lorazepam también es útil y es el de elección en el DHC.

▶ VER CLASE `5.01.1.015` **Trastornos neurocognitivos** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.14 · Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno neurocognitivo mayor (demencia): declive cognitivo objetivo que interfiere con la autonomía en actividades instrumentales (dinero, medicamentos); el menor (deterioro cognitivo leve) tiene déficit objetivo con autonomía preservada.
- Tamizaje: MMSE (corte <24, ajustado por escolaridad; en EMPAM el Minimental abreviado <13 se complementa con Pfeffer ≥6) y MoCA (<26, más sensible para deterioro leve). Diferenciar de delirium (agudo, fluctuante) y depresión.
- Estudio de causas reversibles siempre: TSH, B12, VDRL, hemograma, electrolitos, función renal y hepática, y TAC o RM sin contraste (hematoma subdural crónico, tumor, hidrocefalia normotensiva: marcha magnética, incontinencia y demencia).
- Alzheimer leve a moderado: donepezilo 5→10 mg/día con ECG basal (bradicardia); MMSE <15: agregar memantina. En deterioro cognitivo leve no se indican inhibidores de acetilcolinesterasa.
- Síntomas conductuales: primero medidas no farmacológicas y buscar dolor, retención o infección; si persisten, quetiapina 12,5–25 mg o risperidona 0,25–0,5 mg (riesgo de ACV y mortalidad). Nunca benzodiacepinas.
- Seguimiento: derivar a neurología/geriatría según GES; apoyo al cuidador (escala de Zarit).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 76 años, traída por su hija por olvidos progresivos de 2 años de evolución. Desde hace 6 meses ya no puede manejar sus finanzas ni sus medicamentos y se ha perdido en su barrio. Está vigil, sin fluctuaciones de conciencia ni focalidad neurológica. MoCA 16/30, tamizaje de depresión negativo y exámenes metabólicos normales. **¿Cuál es el diagnóstico sindromático más adecuado?**

A Trastorno neurocognitivo leve

B Pseudodemencia depresiva

C Delirium

D Trastorno neurocognitivo mayor (demencia)

E Envejecimiento cognitivo normal

Respuesta D. Según DSM-5, el trastorno neurocognitivo mayor es un declive cognitivo significativo que interfiere con la independencia en actividades instrumentales (finanzas, medicamentos). En el leve hay declive objetivo pero se conserva la autonomía. La evolución insidiosa, sin fluctuaciones ni alteración de conciencia, descarta delirium.

▶ VER CLASE 5.01.1.016 Trastornos de la personalidad

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.17 · Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno de personalidad: patrón perdurable, inflexible y generalmente egosintónico de vivir y relacionarse, que se inicia en la adolescencia o adultez joven y causa malestar o deterioro.
- Clúster A (raros): paranoide (suspicacia, sin delirio), esquizoide (no desea relaciones), esquizotípico (pensamiento mágico, excentricidad). Clúster B (dramáticos): límite, antisocial (≥18 años con trastorno de conducta antes de los 15), histriónico, narcisista.
- Clúster C (ansiosos): evitativo (desea vínculos pero teme el rechazo), dependiente, obsesivo-compulsivo (perfeccionismo egosintónico, sin obsesiones ni rituales, a diferencia del TOC).
- Límite: inestabilidad afectiva y de relaciones, miedo al abandono, impulsividad, autolesiones, intentos suicidas y vacío crónico; ante gestos suicidas, observación protegida y evaluación psiquiátrica antes del alta.
- Manejo inicial: actitud empática, firme y no punitiva, manejo de crisis y de comorbilidad (depresión, consumo); la psicoterapia es el tratamiento de base (terapia dialéctico-conductual en el límite); fármacos solo sintomáticos y acotados.
- Seguimiento: derivar a salud mental especializada.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 79

Una paciente tiene relaciones interpersonales intensas e inestables y problemas frecuentes con las demás personas. Presenta antecedentes de 2 intoxicaciones medicamentosas y autoagresiones. Además, estuvo en tratamiento por bulimia hace 1 año. Tiene un sentimiento crónico de inutilidad y vacío, y es impulsiva en el consumo de alcohol y en las compras. **¿A qué trastorno de la personalidad corresponde el cuadro?**

A Histriónico

B Limítrofe

C Narcisista

D Antisocial

E Dependiente

Respuesta B. Relaciones intensas e inestables, impulsividad (alcohol, compras, atracones), autoagresiones e intentos suicidas reiterados y sentimiento crónico de vacío son los rasgos nucleares del trastorno límite de la personalidad. El tratamiento de elección es la psicoterapia, como la terapia dialéctico-conductual.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 132

Una paciente de 32 años, madre de 4 hijos, de distintos padres, de los cuales no se hace cargo, tiene relaciones inestables y problemas frecuentes con sus compañeros de trabajo. Pelea frecuentemente con su familia y como antecedente, ha tenido varios episodios de autoagresión e intentos suicidas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Esquizofrenia

B Trastorno límite de la personalidad

C Trastorno bipolar

D Trastorno delirante

E Trastorno depresivo mayor

Respuesta B. Diagnóstico: Trastorno límite de la personalidad (opción B). Es un TP limítrofe clásico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 98

Un paciente de 30 años, consulta debido a que se siente deprimido. Es padre de tres hijos con tres mujeres diferentes, tiene antecedentes de múltiples fracasos académicos y laborales y se encuentra sin actividad laboral en la actualidad. Al interrogatorio, consume alcohol con cierta frecuencia, bebiendo 3 o 4 días a la semana en cantidad que él considera moderada, aunque reconoce que se emborracha los fines de semana. Además, con frecuencia se involucra en actividades riesgosas y presenta una autoimagen negativa. En el pasado, ha tenido ideación suicida con autoagresión, aunque no la tiene en la actualidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Esquizofrenia
B Trastorno de conducta
C Trastorno de personalidad limítrofe
D Trastorno bipolar
E Trastorno adaptativo

Respuesta C. Trastorno de Personalidad Límite: El caso presentado describe un trastorno de personalidad límite clásico. Se recomienda revisar el resumen de psiquiatría.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 112

Una paciente de 28 años tiene problemas frecuentes con sus familiares, con quienes suele pelearse y distanciarse, pero luego de algunos meses retoma la relación, como si nada hubiese pasado. Además tiene antecedente de haber ingerido medicamentos con intención suicida y haberse autoagredido. Además ha cambiado varias veces de trabajo, ya que le cuesta atenerse a las normas, lo que le ha generado problemas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno adaptativo
B Trastorno de personalidad limítrofe
C Trastorno bipolar
D Distimia
E Depresión mayor

Respuesta B. Diagnóstico: Trastorno de personalidad limítrofe (opción B). Es un clásico trastorno limítrofe de la personalidad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 84

Una paciente que desde niña es muy tímida, tiene dificultades para relacionarse con otras peronsonas, por temor al rechazo. No ha tenido pareja y evita las situaciones en que hay muchas personas. Le gustaría mejorar su situación y desarrollar su autoestima. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno de personalidad evitativo
B Trastorno de personalidad dependiente
C Fobia social
D Agorafobia
E Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta A. Diagnóstico: Trastorno de personalidad evitativo (opción A). Cuadro clásico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 58

Una mujer de 23 años quien, desde la niñez es extremadamente introvertida y con baja autoestima por lo que se le es difícil conseguir amigos, por miedo a que pensarán de ella, esto la hace infeliz. En cambio, con su familia es muy cariñosa. El diagnóstico más probable es:

A Trastorno evitativo de la personalidad
B Síndrome de Asperger
C Depresión mayor
D Distimia
E Fobia social

Respuesta A. Es un trastorno evitativo clásico (inicio temprano, pocos amigos, etc.), aunque puede confundirse con una fobia social, sin embargo, en la fobia social sí tienen amigos, solo que no hacen cosas frente a ellos, en las que los puedan juzgar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 122

Una paciente de 28 años tiene relaciones amorosas muy intensas, se viste muy provocativa y es muy coqueta, lo que le ha traído problemas con sus pares a las que ella las llama “envidiosas”. Durante la entrevista es muy exagerada al contar sus problemas. El trastorno de la personalidad más probable en este caso es:

A Narcisista
B Limítrofe
C Histriónico
D Dependiente
E Antisocial

Respuesta C. Tiene mezcla de narcisismo (envidia), limítrofe (intensas), pero más de histriónica (provocativa al vestir, coqueta, exagerada).

▶ VER CLASE 5.01.1.017 Disfunción sexual

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.20 · Sexualidad Humana: Respuesta Sexual, Disfunciones Sexuales, Parafilias, Disforia de Género y Diversidad

QUÉ HAY QUE SABER

- Disfunciones sexuales: trastornos del deseo (hipoactivo), excitación (disfunción eréctil, excitación femenina), orgasmo (anorgasmia, eyaculación precoz o retardada) y dolor genito-pélvico/penetración (vaginismo, dispareunia), persistentes ≥6 meses y con malestar.
- Sospecharlas preguntando activamente en la anamnesis; buscar causas orgánicas (diabetes, enfermedad vascular, hipogonadismo, neuropatía, menopausia con atrofia vulvovaginal) y fármacos (ISRS, antipsicóticos, betabloqueadores, antiandrógenos).
- Factores psicológicos y relacionales: ansiedad de desempeño, depresión, conflictos de pareja, antecedente de abuso sexual.
- Manejo inicial: psicoeducación, abordaje de la pareja, tratar la causa orgánica o ajustar el fármaco (bupropión o mirtazapina tienen menos efecto sexual que ISRS); disfunción eréctil: inhibidores de PDE5 si no hay nitratos.
- Seguimiento: derivar a sexología/psiquiatría, ginecología o urología según el tipo y la causa.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 162

Paciente de 33 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de dolor durante la penetración en las relaciones sexuales, por lo cual se ha negado a mantenerlas en el último mes. Su examen físico no muestra alteraciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trastorno orgásmico femenino
B Trastorno por dolor genito-pélvico/penetración
C Trastorno depresivo mayor
D Trastorno por somatización
E Trastorno del deseo sexual hipoactivo

Respuesta B. El DSM-5 agrupa la dispareunia y el vaginismo en el trastorno por dolor genito-pélvico/penetración: dolor o temor a la penetración por al menos 6 meses, con malestar significativo, sin causa orgánica que lo explique. La evitación de las relaciones es secundaria al dolor, no a falta primaria de deseo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 161

Una paciente de 33 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de dolor durante la penetración en las relaciones sexuales, por lo cual se ha negado a mantenerlas en el último mes. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno orgásmico femenino
B Trastorno por dolor genito-pélvico/penetración
C Trastorno depresivo mayor
D Trastorno por somatización
E Trastorno del deseo sexual hipoactivo

Respuesta B. Dispareunia/Vaginismo: El trastorno por dolor genito-pélvico/penetración (dispareunia superficial o vaginismo) se caracteriza por contracción involuntaria de los músculos vaginales, causando dolor durante la penetración. Difiere del trastorno orgásmico (ausencia de orgasmo) y del deseo hipoactivo (disminución del deseo).

▶ VER CLASE 5.01.1.018 Trastornos de la conducta alimentaria

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.18 · Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Anorexia nerviosa: restricción con peso significativamente bajo (IMC <18,5 en adultos o bajo p5 en niños), miedo intenso a engordar y distorsión de la imagen corporal; subtipos restrictivo y purgativo.
- Signos de desnutrición: bradicardia, hipotensión ortostática, hipotermia, lanugo, piel amarillenta por carotenemia, amenorrea y osteoporosis.
- Hospitalizar de inmediato si IMC <14 (o pérdida >20% en 3 meses), FC <40, PAS <80/50, QTc >460 ms, hipokalemia, hipofosfatemia o hipoglicemia; realimentación lenta con fósforo, magnesio y tiamina para prevenir el síndrome de realimentación (hipofosfatemia).
- Bulimia: atracones con conductas compensatorias ≥1 vez por semana por 3 meses, con peso normal o sobrepeso; signo de Russell, erosión dental e hipertrofia parotídea; hipokalemia por vómitos. Fluoxetina 60 mg/día más TCC.
- Trastorno por atracón: atracones sin conductas compensatorias, con sobrepeso u obesidad.
- Seguimiento: derivar a equipo especializado en TCA; controlar peso, signos vitales y electrolitos mientras tanto.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 17.18

Una adolescente de 16 años consulta traída por su colegio debido a emaciación progresiva. Al examen físico destaca con IMC de 13.5 kg/m², hipotermia de 35.0 °C, presión arterial de 75/45 mmHg y frecuencia cardíaca de 34 lpm en reposo. Se constata lanugo en espalda y abdomen escafoide. La paciente rechaza tener problemas y afirma que solo desea "bajar un par de kilos más". ¿Cuál es la conducta médica inmediata e ineludible?

A Indicar dieta hipercalórica fraccionada y citar a control en un mes en policlínico

B Hospitalización médica inmediata en unidad de cuidados intensivos/intermedios para monitorización cardíaca y realimentación lenta controlada

C Prescribir Fluoxetina 60 mg al día por vía oral y dar el alta a su domicilio

D Derivar a psicoterapia psicoanalítica ambulatoria semanal

E Indicar Metilfenidato matinal para mejorar su motivación de alimentarse

Respuesta B. La paciente presenta una Anorexia Nervosa severa con criterios de hospitalización médica inmediata de urgencia: desnutrición crítica (IMC 13.5 < 14 kg/m²), bradicardia extrema (< 40 lpm: 34 lpm), hipotensión severa (75/45 mmHg) e hipotermia. Estas alteraciones confieren un riesgo inminente de arritmias ventriculares letales, asistolia y colapso circulatorio. La única conducta admisible es la hospitalización inmediata en cama monitorizada (pediatría/UPC), con estabilización hemodinámica y...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 145

Una paciente de 17 años es traída por su padre, quien se muestra muy preocupado porque la considera muy delgada y siente que come muy poco. Relata que solo come una fracción del plato que se sirve en su casa y que deja gran parte de la comida que se le envía al colegio. La paciente comenta que la mayoría de sus compañeras son igualmente delgadas y no considera que tenga un problema, más allá de mostrarse molesta por la insistencia de su padre en consultar. Su IMC es de 16 kg/m². ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno obsesivo de la personalidad

B Bulimia nervosa

C Anorexia nervosa

D Dismorfofobia

E Sana

Respuesta C. Es una anorexia nerviosa clásica (anorexia nervosa en latín) con restricción alimentaria, bajo peso (IMC 16 kg/m²), minimización del problema, normalización de la delgadez y escasa conciencia de problema. Las niñas y adolescentes son el grupo en el que suele comenzar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 4

Mujer de 17 años, con IMC 15.5 kg/m², niega sentirse enferma, refiere que todas sus amigas hacen lo mismo, realiza ejercicio intenso a diario y come menos de un cuarto de su ración habitual. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Anorexia nerviosa

B Bulimia nerviosa

C Trastorno por atracón

D Depresión mayor con anhedonia

E Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta A. Bajo peso severo + restricción alimentaria voluntaria + negación de la enfermedad + ejercicio compulsivo = anorexia nerviosa restrictiva.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 168

Una niña de 15 años presenta disconformidad con su cuerpo, por lo que lo oculta, utilizando ropa 2 o 3 tallas más grandes. Además, tiene retraimiento social y gran preocupación por las calorías que ingiere. Los padres refieren que anda con náuseas en el último tiempo, por lo que come poco y ha bajado de peso. Sin embargo ella se había negado a acudir al médico. El diagnóstico más probable es:

A Trastorno distímico

B Trastorno alimentario mixto

C Anorexia nervosa

D Trastorno depresivo mayor

E Bulimia nervosa

Respuesta C. Es una forma clásica de presentación de la anorexia, aunque no muestren todos los criterios (bajo peso, preocupación por el peso, alteración de la percepción corporal y amenorrea). Es frecuente que la paciente lo oculte, mienta o manipule a la familia, para que no la obliguen a subir de peso.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 45

Paciente de 23 años, que desde hace 6 meses experimenta desánimo, que ella dice que es causado por estar muy disconforme con su figura. Refiere que experimenta momentos en que come muchas galletas, sin parar, hasta ser imposible seguir comiendo, en especial cuando está ansiosa. Además, tiene miedo de reprobar en la universidad. Refiere que 3 veces por semana, puede trotar 5 horas y comer menos de 200 Calorías al día. Niega provocarse vómitos, ya que refiere que no puede inducírselos, aunque ha intentado. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

A Anorexia nervosa

B Trastorno por atracones

C Depresión mayor

D Bulimia nervosa

E Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta D. Es una bulimia, con los atracones característicos y además con la purga, por medio de ejercicios y ayuna (no solo se purga con vómitos o laxantes).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 76

¿Cuál de los siguientes hallazgos del examen físico sugieren un trastorno de conducta alimentaria en una adolescente?

A IMC de 20
B Hipertrofia de las parótidas
C Telangiectasias periorales
D Pulso dicroto
E Hiperpigmentación areolar

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Hipertrofia de las parótidas (opción B). La hipertrofia de parótidas es un signo de vómitos recurrentes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 80

Una paciente de 17 años ha bajado 15 kilogramos en el último tiempo. Su IMC actual es de 16. Tiene mucho miedo a engordar y de hecho quiere bajar un poco más de peso, por lo que luego de comer se induce vómitos, con mucha frecuencia. Está en amenorrea desde hace 4 meses. El diagnóstico más probable es:

A Trastorno alimentario no especificado
B Bulimia nervosa
C Anorexia nervosa
D Depresión mayor
E Distimia

Respuesta C. Diagnóstico: Anorexia nervosa (opción C). La purga no es exclusiva de la bulimia. La anorexia puede tenerla. 1.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 141

Femenina con atracones, luego salía a correr 5 hrs y consumía 200 kcal/día, intentaba vomitar pero no podía:

A Bulimia nerviosa
B Anorexia
C Trastorno por atracones
D Ninguna de las anteriores es correcta
E Todas las anteriores son correctas

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Bulimia nerviosa).

▶ VER CLASE 5.01.1.019 Sexualidad humana y sus alteraciones

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.20 · Sexualidad Humana: Respuesta Sexual, Disfunciones Sexuales, Parafilias, Disforia de Género y Diversidad

QUÉ HAY QUE SABER

- La sexualidad humana integra dimensiones biológicas, psicológicas y sociales (sexo asignado, identidad de género, orientación sexual y expresión de género); la diversidad sexual no es patología.
- Alteraciones: disfunciones sexuales, parafilias (interés sexual atípico intenso) y trastorno parafílico cuando causa malestar o daño a terceros (pedofilia, exhibicionismo, voyeurismo, frotteurismo).
- Sospechar ante consultas indirectas (insomnio, conflictos de pareja, ansiedad), uso de fármacos con efecto sexual o conductas de riesgo; preguntar con lenguaje neutro y confidencial.
- Manejo inicial: escucha sin juicio, psicoeducación, descartar causas orgánicas y farmacológicas, consejería en prevención de ITS y anticoncepción.
- Conductas parafílicas que dañan a terceros (abuso de menores) obligan a protección de la víctima y denuncia; nunca 'terapias de conversión' para la orientación sexual.
- Seguimiento: derivar a sexología o psiquiatría para el tratamiento especializado.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años, derivado por orden judicial. Desde hace 2 años presenta fantasías e impulsos sexuales intensos y recurrentes de mostrar sus genitales a mujeres desconocidas en la vía pública, y lo ha hecho en varias ocasiones. Refiere culpa posterior. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trastorno frotteurista
B Trastorno voyeurista
C Trastorno exhibicionista
D Trastorno fetichista
E Trastorno de travestismo

Respuesta C. Las parafilias son intereses sexuales atípicos; se diagnostican como trastorno parafílico cuando por al menos 6 meses causan malestar, deterioro o se han ejecutado con personas que no consienten. Exponer los genitales a desconocidos es exhibicionismo; observar a otros desnudarse es voyeurismo y tocar o rozar a alguien sin consentimiento es frotteurismo.

▶ VER CLASE **5.01.1.020** **Trastornos somatomorfos** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.5 · Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno de síntomas somáticos (somatización): múltiples síntomas físicos recurrentes de distintos sistemas, por años, con pensamientos, ansiedad o conductas excesivas respecto a ellos, consultas reiteradas y procedimientos innecesarios.
- Variantes: trastorno de ansiedad por enfermedad (hipocondría: miedo a tener una enfermedad grave con pocos síntomas) y trastorno de conversión o neurológico funcional (parálisis, crisis no epilépticas, ceguera sin correlato orgánico).
- Los síntomas no son voluntarios: diferenciar del trastorno facticio (producción intencional para asumir el rol de enfermo) y de la simulación (incentivo externo).
- Descartar enfermedad orgánica con un estudio razonable y no repetitivo; pesquisar depresión y ansiedad comórbidas.
- Manejo inicial: un médico tratante de cabecera, controles programados (no a demanda), validar el malestar sin reforzar exámenes, explicar el origen funcional, TCC; ISRS si hay depresión o ansiedad asociada.
- Seguimiento: derivar a salud mental si el cuadro es grave, hay deterioro importante o comorbilidad.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 57

Paciente de 33 años que hace 5 años comienza con síntomas recurrentes y variables: molestias genitourinarias y gastrointestinales, asociadas a mareos y prurito. Ha consultado en reiteradas ocasiones a especialistas, quienes han descartado enfermedad orgánica, llegando incluso a realizarse una laparoscopía exploradora sin alteraciones. Sus síntomas le impiden trabajar. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hipocondría
B Trastorno facticio
C Trastorno de personalidad
D Trastorno de somatización
E Simulación

Respuesta D. Múltiples síntomas somáticos de distintos sistemas, recurrentes por años, sin causa orgánica, con consultas reiteradas, procedimientos innecesarios y deterioro funcional definen el trastorno de somatización (hoy trastorno de síntomas somáticos). En la hipocondría predomina el miedo a tener una enfermedad grave; en el facticio y la simulación los síntomas se producen voluntariamente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 155

Una paciente de 39 años es despedida de su trabajo y, a las pocas horas, presenta imposibilidad de realizar movimientos con ambas manos. Al examen físico tiene tono muscular y reflejos normales. Además, llama la atención la falta de concordancia entre el relato de los síntomas y la actitud de la paciente, que se ve muy tranquila con lo que sucede. El diagnóstico más probable es:

A Trastorno dismórfico corporal
B Trastorno conversivo
C Trastorno facticio
D Trastorno somatomorfo
E Trastorno disociativo

Respuesta B. Es un trastorno conversivo típico: síntomas neurológicos de inicio rápido y sin una causa orgánica que los explique. En estricto rigor sí es un trastorno somatomorfo (D), ya que los trastornos conversivos son un tipo de trastornos somatomorfos, pero la B es más específica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 88

Un paciente de 50 años presenta cefalea, náuseas, mareos y epigastralgia, de dos años de evolución. Cuenta con múltiples exámenes que descartan causa orgánica, sin embargo, él insiste en exigir más estudios. No se identifica ánimo de obtener alguna ganancia. El diagnóstico más probable es un trastorno:

A Depresivo mayo
B Delirante
C Obsesivo compulsivo
D De somatización
E Facticio

Respuesta D. Diagnóstico: De somatización (opción D). Tiene un T. de somatización clásico. Por no tener ánimo ganancial, no es facticio. Los trastornos somatomorfos se caracterizan por síntomas físicos (somáticos) sin causa orgánica que los explique completamente, de causa psíquica (generalmente estrés).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 142

Una paciente de 41 años que trabaja como ejecutiva en una empresa, consulta por cefalea, náuseas y mareos frecuentes y recurrentes. Su examen físico es normal y refiere sentirse estresada y exigida en su trabajo, ya que los resultados de la empresa dependen de su desempeño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno somatomorfo
B Trastorno disociativo
C Trastorno conversivo
D Trastorno facticio
E Trastorno adaptativo de tipo ansioso

Respuesta A. Trastorno Somatomorfo: Este audio describe un trastorno somatomorfo, caracterizado por síntomas físicos sin una causa orgánica subyacente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 70

Un paciente sufre una fractura de muñeca, en relación a un accidente laboral. Presenta con mucho dolor, a pesar de haber evolucionado bien y de llevar mucho tiempo desde el accidente. Tiene antecedente de cuadros previos similares, con dolores crónicos y difíciles de tratar. El diagnóstico más probable es:

A Trastorno somatomorfo
B Trastorno conversico
C Trastorno de estrés postraumático
D Depresión reactiva
E Trastorno facticio

Respuesta A. Es un trastorno somatomorfo por dolor (no por somatización, ni hipocondriaco). No hay información para pensar que sea facticio (intencional para ganar cuidados y afecto) ni simulación (intencional, para ganar dinero o pensiones).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 115

Una paciente de 50 años consulta por dolor abdominal, asociado a náuseas y malestar general. Además ha tenido disestesias en la piernas y sensación de frío, más otras molestias inespecíficas. Refiere estar angustiada por lo que le sucede y relata que está pasando por un periodo de estrés. Se solicitan exámenes que descartan patología orgánica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno somatomorfo
B Trastorno conversivo
C Trastorno hipocondriaco
D Trastorno facticio
E Depresión

Respuesta E. Diagnóstico: Depresión (opción E). Es un trastorno de somatización clásico. Ánimo bajo persistente por más de dos semanas, anhedonia, alteraciones del sueño y fatiga cumplen criterios diagnósticos para episodio depresivo mayor (Garantía GES en APS). El tratamiento de primera línea incluye psicoterapia e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS como sertralina).

▶ VER CLASE 5.01.1.021 Trastornos disociativos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.9 · Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastornos disociativos: alteración de la integración de conciencia, memoria, identidad, percepción o conducta, frecuentemente tras trauma grave (abuso sexual, violencia).
- Amnesia disociativa: incapacidad de recordar información autobiográfica, habitualmente de un evento traumático, sin causa orgánica; puede acompañarse de fuga disociativa (viaje con amnesia de identidad).
- Despersonalización/desrealización: sentirse ajeno al propio cuerpo o al entorno con juicio de realidad conservado; trastorno de identidad disociativo: dos o más estados de personalidad con lagunas amnésicas.
- Antes de diagnosticar: descartar causas orgánicas y tóxicas (epilepsia del lóbulo temporal, TEC, intoxicación, amnesia global transitoria, delirium) y distinguir de TEPT con síntomas disociativos.
- Manejo inicial: ambiente seguro, contención, no forzar el recuerdo, evaluar riesgo suicida y de violencia; no hay fármaco específico.
- Seguimiento: derivar a psiquiatría para psicoterapia especializada (centrada en el trauma).

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 59

Mujer de 18 años sufrió un rapto por dos desconocidos al salir de la oficina. Es encontrada por terceros en un sitio eriazo, con evidentes signos de abuso sexual, sin lesiones físicas. En el Servicio Médico Legal se constata la violación. Ella no recuerda nada de lo sucedido: solo cuando fue abordada por los desconocidos y luego cuando estaba en el Servicio Médico Legal. Se muestra muy preocupada, pero no logra recordar lo ocurrido entremedio. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trastorno conversivo
B Trastorno de estrés postraumático
C Trastorno facticio
D Trastorno adaptativo
E Trastorno disociativo

Respuesta E. La incapacidad de recordar información autobiográfica de un evento traumático, sin causa orgánica, corresponde a una amnesia disociativa, dentro de los trastornos disociativos. El estrés postraumático exige reexperimentación, evitación e hiperalerta por más de un mes; aquí el cuadro es inmediato y el síntoma central es la laguna amnésica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 114

Una mujer de 18 años subió a un taxi, en el que el taxista se desvió del camino que debía tomar, siendo luego agredida por él. Es encontrada por terceras personas en un sitio eriazo, con evidentes signos de haber sido abusada sexualmente. Fue trasladada al Servicio Médico Legal, donde se constató la violación. Sin embargo, ella no recuerda nada de los sucedido, recordando solo cuando estaba en el taxi y luego cuando estaba en el Servicio Médico Legal. Ella se muestra muy preocupada, pero no logra recordar nada de lo que aconteció entremedio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno conversivo
B Trastorno de estrés postraumático
C Trastorno facticio
D Trastorno adaptativo
E Trastorno disociativo

Respuesta E. Diagnóstico: Trastorno disociativo (opción E). Es una amnesia disociativa clásica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 12

Una paciente de 59 años, luego de una pelea con su marido, se va de su casa y es en- contrada varias horas después sin recordar lo sucedido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno facticio
B Trastorno disociativo
C Trastorno somatomorfo
D Trastorno conversivo
E Trastorno adaptativo

Respuesta B. Diagnóstico: Trastorno disociativo (opción B). Es una fuga disociativa clásica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 180

Una paciente de 23 años no llega a su domicilio luego de un conflicto familiar grave, siendo encontrada dos días después en una ciudad diferente, en buenas condiciones generales. Ella no recuerda nada de lo sucedido en ese intervalo de tiempo y no parece estar preocupada por ello. Su examen neurológico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Amnesia global transitoria
B Episodio psicó2co breve
C Trastorno conversivo
D Trastorno de estrés agudo
E Trastorno disocia2vo

Respuesta E. Tiene una fuga disociativa clásica, que es un Gpo de amnesia disociativa, en la que, además, se produce una “fuga” desde su lugar habitual. No se debe confundir con la amnesia global transitoria, que es un Gpo de accidente isquémico transitorio cerebral (se debe buscar fuente embólica), que se caracteriza por desorientación y amnesia (repitiendo las mismas preguntas), autolimitado, de pocas horas de evolución.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 130

Una paciente de 25 años fue encontrada vagando por la calle descalza, desorientada y confusa. Hace 5 horas había tenido una discusión con su padre, luego de lo cual salió de su casa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno disociativo
B Trastorno adaptativo
C Trastorno conversivo
D Trastorno somatomorfo
E Trastorno facticio

Respuesta A. Diagnóstico: Trastorno disociativo (opción A). Es una fuga disociativa clásica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 26

Una paciente de 40 años, con antecedente de cuatro episodios depresivos tratados y usuaria de fluoxetina de forma permanente, cursa un nuevo episodio luego de separación con su marido. En su último control se encontraba de mejor ánimo ya que asistiría al casamiento de su hija. Actualmente consulta muy preocupada porque hace aproximadamente una semana atrás, su mano derecha intentó atacarla, pero se defendió con la su mano izquierda y ayuda de familiares. El diagnóstico más probable en este caso es:

A Trastorno conversivo
B Trastorno delirante
C Psicosis
D Trastorno disociativo
E Trastorno por somatización

Respuesta D. Hizo un trastorno disociativo grave, con despersonalización parcial. Es una pregunta muy difícil, ya que no es el cuadro clásico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 107

Un paciente es despedido de su trabajo, luego de ser sorprendido robando. Evoluciona con paresia de ambas manos. Al examen neurológico no tiene alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno conversivo
B Trastorno facticio
C Trastorno de somatización
D Trastorno adaptativo
E Trastorno disociativo

Respuesta A. Diagnóstico: Trastorno conversivo (opción A). Es un trastorno conversivo clásico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 69

Una mujer de 40 años pierde súbitame la movilidad de ambos brazos. Esto sucede en relación a la reactivación de un conficto familiar. Al examen físico se aprecia una disociación con los síntomas, por lo que se descarta patología orgánica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno somatomorfo
B Trastorno facticio
C Trastorno conversivo
D Trastorno disociativo
E Trastorno adaptativo

Respuesta C. Diagnóstico: Trastorno conversivo (opción C). Cuadro clásico (síntomas neurológicos de inicio súbito).

▶ VER CLASE 5.01.1.022 **Trastornos facticios** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.19 · Psiquiatría General: Clasificaciones (DSM-5/CIE-10), Higiene del Sueño, Trastornos Facticios y Nociones de Psiquiatría Forense

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno facticio: falsificación o producción intencional de signos o síntomas (inyectarse insulina, contaminar heridas o muestras, autolesiones) para asumir el rol de enfermo, sin incentivo externo evidente; forma crónica grave: síndrome de Münchhausen.
- Facticio impuesto a otro (Münchhausen por poderes): un cuidador, habitualmente la madre, produce o inventa síntomas en un niño; es una forma de maltrato infantil.
- Sospechar ante cuadros inexplicables o que no responden, historias inconsistentes, múltiples hospitalizaciones en distintos centros, conocimiento médico y aceptación ansiosa de procedimientos invasivos.
- Diferenciar de simulación (producción intencional con incentivo externo: licencia, indemnización, evitar la cárcel) y de trastorno de síntomas somáticos (no intencional).
- Manejo inicial: confrontación no punitiva, evitar procedimientos innecesarios, coordinar un solo equipo tratante y tratar la comorbilidad; en la forma por poderes, proteger al niño, registrar y denunciar.
- Seguimiento: derivar a psiquiatría.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 163

Paciente de 22 años es hospitalizada por un cuadro de diarrea, vómitos y dolor abdominal de difícil manejo. Durante la hospitalización es sorprendida ingiriendo laxantes, autoinduciéndose vómitos y adulterando la temperatura del termómetro. Los exámenes descartan patología orgánica y, luego de indagar, no se encuentra ninguna ganancia evidente con estos síntomas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trastorno conversivo
B Trastorno facticio
C Trastorno delirante
D Trastorno bipolar
E Trastorno de la conducta alimentaria

Respuesta B. En el trastorno facticio la persona produce o finge síntomas de forma intencional para asumir el rol de enfermo, sin incentivos externos evidentes. Si hubiera ganancia externa (licencia, dinero) sería simulación; en el conversivo los síntomas no son voluntarios. Los laxantes y vómitos no buscan bajar de peso, sino parecer enfermo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 102

Un paciente presenta dolor abdominal y vómitos desde hace 5 días, y tiene una actitud muy demandante y agresiva, solicitando la realización de exámenes y administración de medicamentos. En una ocasión fue sorprendido tomando laxantes y adulterando la temperatura del termómetro. Además, hace un año estuvo hospitalizado por un cuadro similar, hecho que él no refirió en la consulta. Al indagar un poco más, se concluye que no tiene una causa orgánica que explique sus síntomas, pero que tampoco hay una ganancia evidente para él. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno por hipocondría
B Trastorno de somatización
C Trastorno delirante crónico
D Episodio psicótico breve
E Trastorno facticio

Respuesta E. Diagnóstico: Trastorno facticio (opción E). Al hacerlo intencionalmente, es un trastorno facticio clásico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 131

Un paciente de 46 años presenta múltiples síntomas, como cefalea, molestias abdominales, calambres, astenia, entre otros, desde hace un año. Se han realizado múltiples exámenes, sin encontrar una causa orgánica. Llama la atención que ha tenido proteinuria persistente, que no se correlaciona con el cuadro clínico, ni con los demás exámenes, por lo que se tienen fuertes sospechas de que ha manipulado las muestras de orina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno somatomorfo
B Trastorno conversivo
C Trastorno facticio
D Trastorno disociativo
E Trastorno hipocondriaco

Respuesta C. Diagnóstico: Trastorno facticio (opción C). La sospecha de manipulación de los exámenes, hace que sea facticio.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 172

Un paciente de 57 años presenta múltiples síntomas difíciles de precisar. Se ha realiza múltiples exámenes y evaluaciones médicas, sin poder llegar a un diagnóstico. Sin embargo, él insiste en que está muy enfermo y no puede realizar actividades básicas, como asearse. Hace 2 años fue pensionado por esto, sin cambiar su conducta. Su esposa lo cuida y lo asiste abnegadamente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno por simulación
B Trastorno hipocondríaco
C Trastorno de somatizaicón
D Trastorno facticio
E Trastorno de personalidad dependiente

Respuesta D. Que se haya pensionado hace sospechar un T. por simulación, pero que no cambie su conducta y que su vida esté tan afectada, hace sospechar más un T. facticio. También el hecho de que su mujer lo cuide abnegadamente (fin ganancial de afecto, atención y cuidados).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 47

Una paciente de 30 años, diabética tipo 1, con historia de 5 hospitalizaciones en el último año por cuadros de hipoglicemia severa. Actualmente ingresa en shock hipogli- cémico, el que es manejado adecuadamente. Durante su hospitalización, es sorprendida en el baño inyectándose una dosis de insulina que no le correspondía, lo cual ella poste- riormente niega. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno disociativo
B Trastorno somatomorfo
C Trastorno hipocondriaco
D Trastorno por simulación
E Trastorno facticio

Respuesta E. Diagnóstico: Trastorno facticio (opción E). Es un trastorno facticio clásico. No es por simulación, porque no hay un fin económico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 85

Una joven que consulta por diarrea de meses, exige que la hospitalicen para estudio. Estudio normal. La pillan tomando laxantes, ella lo niega, no se sabe motivo por el que hace esto. ¿Cual es el diagnóstico? a. Trastorno facticio

A Hemograma y VHS
B Ecografía
C Radiografía
D TAC con contraste
E Resonancia magnética

Respuesta A. Diagnóstico: Hemograma y VHS (opción A).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 131

Una paciente de 19 años, ha sido hospitalizada 8 veces por hipoglicemias, sin una causa clara, que han requerido hospitalización y que se resuelven fácilment

E En la última hospitalización, fue sorprendida inyectándose una dosis de insulina en el baño. Sin embargo, ella niega abiertamente este hecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno disociativo

B Trastorno conversivo

C Trastorno somatomorfo

D Trastorno facticio

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (En la última hospitalización, fue sorprendida inyectándose una dosis de insulina en el baño. Sin embargo, ella niega abiertamente este hecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 34

Un paciente de 50 años relata que, al llegar a su trabajo en auto, se le "descompuso el cuerpo", sintiendo rigidez generalizada en todos sus músculos, lo que le impidió entrar a su trabajo y lo obligó a devolverse a su casa. Además, presentó pérdida de conciencia con movimientos repetitivos en su casa, razón por la cual fue llevado al servicio de urgencias. Refiere malestar, angustia y desasosiego de varios días de evolución. Al examen físico tiene un examen neurológico estrictamente normal y su resonancia magnética nuclear descarta lesiones. Sus familiares refieren que siempre ha sido un buen trabajador y excelente padre, por lo que no entienden bien qué le está pasando. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno depresivo

B Trastorno conversivo

C Trastorno adaptativo

D Trastorno facticio

E Trastorno disociativo

Respuesta D. Diagnóstico: Trastorno facticio (opción D).

▶ VER CLASE 5.01.1.023 Trastorno del espectro autista

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.18 · Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- TEA: déficit persistente de comunicación e interacción social recíproca (contacto visual, atención conjunta, juego simbólico) más patrones restringidos y repetitivos (estereotipias, rigidez ante cambios, intereses restringidos, alteraciones sensoriales), desde la infancia temprana.
- Señales de alerta: no balbucear a los 12 meses, no señalar ni decir palabras a los 16–18 meses, no combinar 2 palabras a los 24 meses, no responder a su nombre y cualquier pérdida de lenguaje o habilidad social.
- Pesquisa con M-CHAT-R/F (16–30 meses) en el control de salud; ante retraso del lenguaje descartar siempre hipoacusia con evaluación auditiva objetiva.
- Manejo inicial: derivación precoz a evaluación diagnóstica especializada (neurología infantil/psiquiatría, fonoaudiología, terapia ocupacional) sin esperar; orientación a la familia.
- La intervención temprana conductual y del lenguaje mejora el pronóstico; risperidona o aripiprazol solo para irritabilidad o agresividad grave, por especialista.
- Seguimiento: derivar; buscar comorbilidades (discapacidad intelectual, epilepsia, TDAH, ansiedad) y apoyar la inclusión escolar.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 1

Paciente de 20 años presenta episodios de descontrol y agresividad en los que rompe objetos, grita y amenaza con agredir y autoagredirse. Se molesta mucho cuando le cambian sus cosas de lugar y tiene rutinas muy marcadas que le cuesta modificar. Abandonó la secundaria tras reprobar dos veces primero medio. Tiene muy buena memoria, al punto de memorizar códigos de barras de productos. Desde niño fue considerado raro, no entablaba amistades, jugaba solo siempre con el mismo juguete y veía repetidamente sus dos películas favoritas. Saluda de manera extraña, con aleteo de sus extremidades superiores. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Esquizofrenia

B Trastorno bipolar

C Trastorno de personalidad limítrofe

D Trastorno del espectro autista

E Trastorno estereotipado del movimiento

Respuesta D. El trastorno del espectro autista combina déficit persistente en la comunicación e interacción social desde la infancia con patrones restringidos y repetitivos: rutinas rígidas, intereses intensos, estereotipias motoras como el aleteo. Los episodios de descontrol ante cambios son frecuentes. El trastorno estereotipado del movimiento no explica el déficit social.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 105

Niño de 3 años con antecedente de autismo. Presenta episodios de golpear su cabeza contra la pared repetidamente, varias veces al día. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Derivar a psiquiatría infantil para evaluación y manejo conductual

B Hospitalizar de urgencia

C Iniciar haloperidol

D Solicitar EEG para descartar epilepsia

E Solo observar

Respuesta A. Conductas autolesivas en niño con TEA (autismo): derivar a psiquiatría infantil + equipo de terapia conductual (ABA). Las conductas repetitivas y autolesivas son parte del espectro autista y requieren manejo especializado.

▶ VER CLASE 5.01.1.024 Trastorno específico del aprendizaje escolar

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.18 · Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno específico del aprendizaje: dificultad persistente en lectura (dislexia), escritura (disgrafía/disortografía) o cálculo (discalculia), muy por debajo de lo esperado para la edad, con inteligencia normal.
- Sospechar ante bajo rendimiento escolar selectivo, lectura lenta con errores, inversión de letras o dificultad con números pese a escolarización adecuada; persiste ≥6 meses pese a apoyo.
- Antes de diagnosticar: descartar déficit visual o auditivo, discapacidad intelectual (WISC), TDAH, trastornos emocionales, problemas familiares y escolarización deficiente.
- Manejo inicial: evaluación psicopedagógica y apoyo en el colegio con adecuaciones curriculares (Programa de Integración Escolar), coordinación con la familia.
- Seguimiento: derivar a evaluación especializada (psicopedagogía, neurología o psiquiatría infantil) y pesquisar baja autoestima o ansiedad secundaria.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 8 años, en tercero básico, derivado por bajo rendimiento en lenguaje. Lee lento, con omisiones e inversiones de letras y mala comprensión lectora, pese a apoyo escolar por un año. Su rendimiento en matemáticas es adecuado. La evaluación con WISC muestra un coeficiente intelectual de 102, y su audición y visión son normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Discapacidad intelectual leve

B Trastorno del espectro autista

C Trastorno por déficit atencional

D Trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura

E Trastorno del desarrollo del lenguaje expresivo

Respuesta D. El trastorno específico del aprendizaje es una dificultad persistente en una habilidad académica (lectura, escritura o cálculo), muy por debajo de lo esperado, pese a intervención, con inteligencia normal y sin déficit sensorial que lo explique. La dislexia es la forma más frecuente. Un CI normal descarta discapacidad intelectual.

▶ VER CLASE 5.01.1.025 Retardo mental

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.18 · Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Discapacidad intelectual (retardo mental): déficit de funciones intelectuales (CI <70 en WISC/WAIS) y del funcionamiento adaptativo (conceptual, social, práctico), con inicio en el período del desarrollo.
- Grados: leve (CI 50–69, la mayoría), moderado (35–49), grave (20–34) y profundo (<20); hoy la gravedad se define sobre todo por el funcionamiento adaptativo.
- Causas: síndrome de Down (más frecuente genética), X frágil (más frecuente hereditaria), síndrome alcohólico fetal (más frecuente prevenible), hipotiroidismo congénito y PKU (pesquisa neonatal), asfixia, infecciones congénitas.
- Sospecha: retraso global del desarrollo en EEDP/TEPSI, dificultades escolares globales o conductas disruptivas; descartar hipoacusia y déficit visual.
- Manejo inicial: evaluación psicométrica, estudio etiológico básico y estimulación temprana; apoyo educativo (educación especial o PIE) y familiar.
- Seguimiento: derivar a neurología/genética y salud mental infantil; pesquisar comorbilidades (epilepsia, TEA, TDAH) y prevenir maltrato y abuso.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 7 años con retraso del lenguaje desde los 2 años. En el colegio no logra aprender a leer, requiere ayuda para vestirse y le cuesta seguir instrucciones de 2 pasos. La evaluación con WISC muestra un coeficiente intelectual total de 60, con perfil homogéneamente descendido. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Discapacidad intelectual leve

B Discapacidad intelectual moderada

C Discapacidad intelectual grave

D Inteligencia limítrofe

E Trastorno específico del aprendizaje

Respuesta A. La discapacidad intelectual (antes retardo mental) requiere déficit intelectual y adaptativo de inicio en el desarrollo. Por CI se clasifica en leve (50-69), moderada (35-49), grave (20-34) y profunda (bajo 20); la inteligencia limítrofe es 70-84. DSM-5 gradúa además por funcionamiento adaptativo. Con CI de 60 y déficit adaptativo, es leve.

▶ VER CLASE 5.01.1.026 Enuresis

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.18 · Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Enuresis: emisión involuntaria de orina durante el sueño en niños ≥5 años, al menos 2 veces por semana por 3 meses; primaria (nunca controló, la más frecuente) o secundaria (tras ≥6 meses seco: buscar estresor o causa orgánica).
- Monosintomática (solo nocturna) vs no monosintomática (urgencia, incontinencia diurna, constipación): esta última requiere estudio y tratar la disfunción vesical e intestinal.
- Estudio: anamnesis, examen físico (columna lumbosacra, genitales), orina completa ± urocultivo (ITU, glucosuria, densidad baja) y diario miccional; descartar diabetes, ITU, apnea del sueño y constipación.
- Tratamiento: educación sin castigo ni culpa, orinar antes de dormir y restringir líquidos nocturnos; primera línea alarma de enuresis (8–12 semanas) o desmopresina 120–240 µg sublingual (o 0,2–0,4 mg oral) antes de dormir, restringiendo líquidos por riesgo de hiponatremia.
- Remisión espontánea ~15% por año; tratar constipación asociada.
- Seguimiento completo: control de respuesta con calendario seco/mojado; retiro gradual de desmopresina; derivar si es secundaria con causa orgánica, no monosintomática refractaria o falla del tratamiento.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 7 años, traído porque moja la cama 4 noches por semana. Nunca ha estado seco por más de 6 meses. No tiene síntomas urinarios diurnos ni constipación, su examen físico es normal y el examen de orina es normal. La familia lo reta cada mañana. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Derivar a urología para cistoscopía

B Iniciar imipramina

C Solicitar ecografía renal y uretrocistografía miccional

D Iniciar oxibutinina

E Educación a la familia, eliminar castigos y medidas conductuales como calendario y micción antes de dormir

Respuesta E. Enuresis nocturna primaria monosintomática: se diagnostica desde los 5 años. Con examen y orina normales no requiere estudio de imágenes. Se inicia con educación, eliminar castigos y medidas conductuales; si persiste, la alarma de enuresis o la desmopresina son las terapias de primera línea. La imipramina ya no se usa por su cardiotoxicidad.

▶ VER CLASE 5.01.1.027 Encopresis

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.2 · Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Encopresis: emisión de deposiciones en lugares inapropiados en niño ≥4 años, al menos 1 vez al mes por 3 meses; la forma más frecuente es retentiva, por constipación funcional con fecaloma y escurrimiento por rebalse.
- Sospecha: niño que mancha la ropa interior casi a diario con deposiciones blandas y defeca deposiciones duras, voluminosas y dolorosas cada varios días; masa fecal palpable en hipogastrio.
- Banderas rojas de organicidad: retraso en la eliminación de meconio (Hirschsprung, ampolla vacía), alteraciones de columna lumbosacra, déficit neurológico o mal incremento.
- Manejo inicial: educación sin castigo; desimpactación con polietilenglicol oral en dosis altas (o enemas), luego polietilenglicol de mantención por meses, sentarse en el baño tras las comidas, fibra y agua.
- Encopresis no retentiva o asociada a estrés familiar, abuso o conducta oposicionista: evaluación de salud mental.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología o salud mental infantil si no responde, hay sospecha orgánica o componente psicológico relevante.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 6 años, controla esfínteres desde los 3 años. Desde hace 4 meses ensucia su ropa interior casi a diario con deposiciones blandas. Defeca deposiciones duras y voluminosas cada 5 días, con dolor. Al examen se palpa masa fecal en hipogastrio y el tacto rectal muestra ampolla llena de heces duras. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Loperamida para controlar el escurrimiento

B Desimpactación fecal, luego polietilenglicol de mantención y entrenamiento de hábito defecatorio

C Psicoterapia exclusiva, sin tratamiento laxante

D Dieta sin gluten

E Biopsia rectal por sospecha de enfermedad de Hirschsprung

Respuesta B. La encopresis retentiva es la más frecuente: la constipación funcional con fecaloma produce escurrimiento de heces por rebalse. Se trata con desimpactación (polietilenglicol en dosis altas o enemas), mantención con polietilenglicol por meses, educación sin castigo y hábito defecatorio postprandial. El Hirschsprung se sospecha con inicio neonatal y ampolla vacía.

▶ VER CLASE 5.01.1.028 Trastorno por déficit atencional

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.18 · Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- TDAH: ≥6 síntomas de inatención y/o ≥6 de hiperactividad-impulsividad por ≥6 meses (5 desde los 17 años), presentes antes de los 12 años, en ≥2 contextos (casa y colegio) y con deterioro académico o social.
- Presentaciones: combinada (la más frecuente), inatenta (frecuente en niñas, pasa desapercibida) e hiperactiva-impulsiva; heredabilidad ~75%.
- Antes de diagnosticar: descartar déficit visual o auditivo, discapacidad intelectual, trastorno del aprendizaje, ansiedad, depresión, maltrato y problemas del sueño; usar cuestionarios a padres y profesores (Conners).
- Tratamiento inicial: intervención multimodal (psicoeducación, manejo conductual parental, apoyo y adecuaciones escolares) y metilfenidato como fármaco de primera línea en escolares (acción corta o prolongada).
- Efectos del metilfenidato: disminución del apetito, insomnio de conciliación, cefalea y alza leve de FC y PA; controlar peso, talla, PA y FC en cada visita.
- Seguimiento completo: controles periódicos de respuesta escolar y efectos adversos; derivar si hay comorbilidad importante, duda diagnóstica o falta de respuesta.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 17.18

Un niño de 8 años es traído a consulta médica porque su profesora señala que se para constantemente de su asiento en clases, habla sin parar, interrumpe a sus compañeros y no termina las guías escolares por distraerse con cualquier estímulo. Los padres relatan que en la casa el niño presenta la misma conducta desde los 5 años: no logra mantenerse sentado a la mesa, pierde constantemente los lápices y cuadernos, y le cuesta seguir instrucciones de más de un paso. Su coeficiente intelectual y examen neurológico son normales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y el fármaco de primera línea?

A Trastorno del espectro autista; iniciar Risperidona

B Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH); tratamiento farmacológico de primera línea con Metilfenidato asociado a intervenciones psicopedagógicas

C Trastorno bipolar maníaco precoz; iniciar Carbonato de Litio

D Trastorno oposicionista desafiante puro; internación en centro psiquiátrico

E Depresión infantil enmascarada; indicar Sertralina

Respuesta B. El paciente cumple los criterios diagnósticos DSM-5 para Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) subtipo combinado: presencia de síntomas de inatención, hiperactividad motora e impulsividad presentes de forma continua durante más de 6 meses, que debutaron antes de los 12 años (presentes desde los 5 años) y que se manifiestan de forma consistente en al menos dos entornos diferentes (colegio y hogar), produciendo disfunción escolar. El tratamiento farmacológico de primera...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 70

Una mujer de 30 años, ingeniera civil, refiere que desde su infancia se le pierden con frecuencia las cosas y que le es difícil realizar tareas, en especial porque las procrastina y le cuesta terminarlas una vez iniciadas. Por ello realiza listas de todas las cosas que debe hacer a modo de cumplir con ellas. Recientemente, en su trabajo ha aumentado su carga laboral y responsabilidades, lo que la tiene agobiada y angustiada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno del espectro au2sta

B Trastorno obsesivo compulsivo

C Trastorno de personalidad

D Trastorno por déficit atencional hiperac2vo

E Trastorno de angus2a generalizada

Respuesta D. Es un TDAH clásico, de alta capacidad (logró ser ingeniera). Se maneja con técnicas de trabajo y, en algunos casos, fármacos estimulantes como el metilfenidato y anfetaminas (ej. lisdexanfetamina).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 155

Una paciente de 27 años consulta por ansiedad y ánimo bajo. Refiere antecedentes de problemas de inquietud psicomotora durante la infancia y se considera olvidadiza y desordenada. Refiere que recientemente cambió de puesto de trabajo, presentando errores y dificultades, lo que le ha generado problemas, sintiéndose ansiosa y con ánimo bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno por déficit atencional de tipo hiperactivo
B Trastorno de personalidad
C Trastorno de ansiedad social
D Trastorno de ansiedad generalizada
E Trastorno bipolar

Respuesta A. Déficit Atencional en Adultos: Este audio describe un cuadro clínico compatible con déficit de atención del adulto de tipo hiperactivo, con síntomas depresivos y ansiosos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 176

Universitaria con dificultad para prestar atención, historia de dificultad para concretar tareas y para seguir el hilo de conversación. ¿Diagnóstico más probable?

A Trastorno de ansiedad generalizada
B Trastorno depresivo mayor
C Trastorno de personalidad limítrofe
D Trastorno del espectro autista (TEA)
E Trastorno por déficit de atención (TDA)

Respuesta E. Diagnóstico: Trastorno por déficit de atención (TDA) (opción E). Trastorno por déficit de atención (TDA).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 86

Un paciente de 25 años presenta mal rendimiento en la universidad, habiendo reprobado una de las asignaturas. Refiere que no se concentra en sus estudios y que no alcanza a leer toda la materia. En la entrevista se ve verborreico, inquieto y teatral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno histriónico de la personalidad
B Déficit atencional
C Trastorno bipolar
D Insuficiencia intelectual leve
E Síndrome de Asperger

Respuesta B. Diagnóstico: Déficit atencional (opción B). Cuadro clásico.

▶ VER CLASE 5.01.1.029 Intento de suicidio en niños y adolescentes

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.3 · Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización

QUÉ HAY QUE SABER

- Intento suicida adolescente: siempre es grave y requiere evaluación; factores de riesgo: intento previo (el más potente), depresión, consumo de sustancias, conflictos familiares, abuso, bullying, diversidad sexual sin apoyo, impulsividad y acceso a medios.
- Señales de alarma: carta o mensajes de despedida, regalar pertenencias, hablar de morir, aislamiento, autolesiones, búsqueda de métodos; preguntar directamente no induce el suicidio.
- Manejo inicial: tratar lo médico primero (paracetamol: N-acetilcisteína; tricíclicos: ECG), observación protegida sin dejarlo solo, retirar medios letales y evaluación psiquiátrica antes de cualquier alta.
- Hospitalizar si hay plan estructurado, intención de morir, arrepentimiento de haber sobrevivido, ideación persistente, psicosis o falta de red que supervise; los contratos de no suicidio no sirven.
- En riesgo vital se rompe la confidencialidad para informar a los padres; el ISRS no protege en el corto plazo (la fluoxetina es de elección si hay depresión, vigilando el inicio).
- Seguimiento: derivar a salud mental infanto-juvenil con control precoz tras el alta (alto riesgo de repetición en los meses siguientes).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 87

Una adolescente de 15 años se intenta suicidar, ingiriendo 600 miligramos de amitriptilina. ¿Cuál es el examen más adecuado para determinar su riesgo? **¿Cuál es el examen más adecuado para determinar su riesgo?**

A Gases arteriales
B Bilirrubinemia
C Electrocardiograma
D Creatinfosfoquinasa
E Pruebas hepáticas

Respuesta C. La intoxicación por tricíclicos produce alteraciones de la conducción y arritmias ventriculares, que son lo más grave. El electrocardiograma (QRS ancho) permite estimar el riesgo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Adolescente de 15 años es traída a urgencia tras ingerir 20 comprimidos de paracetamol después de una discusión con su pareja. Está estable, sin compromiso de conciencia, y ya recibió manejo toxicológico. En la entrevista refiere que quería morir, que lo planificó por una semana, que lamenta seguir viva y que lo volvería a intentar. **Una vez estabilizada médicamente, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Derivar solo a psicólogo del colegio

B Alta con control en CESFAM en un mes

C Alta con sertralina y control en 2 semanas

D Alta a su domicilio si los padres se comprometen a vigilarla

E Hospitalización con evaluación psiquiátrica urgente y supervisión continua

Respuesta E. Todo intento suicida en un adolescente requiere evaluación psiquiátrica antes del alta. Planificación, intención de morir, arrepentimiento de sobrevivir e ideación persistente indican alto riesgo, por lo que corresponde hospitalizar con supervisión continua. Los antidepresivos no protegen en el corto plazo y el compromiso familiar no basta con este nivel de riesgo.

▶ VER CLASE 5.01.1.030 Trastorno conducta oposicionista desafiante

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.18 · Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno oposicionista desafiante: patrón ≥6 meses de enojo o irritabilidad, discusiones y desafío a la autoridad, y vengatividad, con ≥4 síntomas, hacia adultos y figuras de autoridad, que excede lo esperable para la edad.
- No hay violación grave de derechos de otros ni de normas sociales mayores (eso es trastorno disocial); suele comenzar en preescolares y escolares.
- Buscar comorbilidad y factores contribuyentes: TDAH (muy frecuente), trastornos del ánimo y ansiedad, trastornos del aprendizaje, crianza inconsistente o violenta, VIF y maltrato.
- Manejo inicial: psicoeducación y entrenamiento parental (normas claras y consistentes, refuerzo positivo, consecuencias predecibles, evitar castigo físico), coordinación con el colegio.
- No hay fármaco específico; se trata la comorbilidad (por ejemplo TDAH).
- Seguimiento: derivar a salud mental infanto-juvenil para terapia familiar/parental.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 8 años traído por sus padres porque, desde hace 8 meses, discute constantemente con los adultos, se niega a cumplir normas en casa y en el colegio, molesta deliberadamente a otros, se enoja con facilidad, es rencoroso y culpa a los demás de sus errores. No ha agredido físicamente a personas ni animales, no ha robado ni destruido propiedad. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trastorno explosivo intermitente

B Trastorno disocial

C Trastorno por déficit atencional

D Trastorno negativista desafiante (oposicionista)

E Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo

Respuesta D. El trastorno negativista desafiante es un patrón de al menos 6 meses de ánimo irritable, conducta desafiante y vengativa contra figuras de autoridad, sin violar derechos básicos de otros. Si hubiera agresión, robos, destrucción o crueldad sería trastorno disocial. El tratamiento de primera línea es el entrenamiento parental.

▶ VER CLASE 5.01.1.031 Trastorno conducta disocial

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.18 · Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno disocial (de conducta): patrón repetitivo de violación de derechos de otros o de normas sociales, con ≥3 criterios en 12 meses: agresión a personas o animales, destrucción de propiedad, engaño o robo y violaciones graves de normas (fugas, ausentismo).
- Inicio infantil (antes de los 10 años, peor pronóstico) o adolescente; con rasgos de insensibilidad emocional (falta de culpa y empatía) es más grave.
- Es precursor del trastorno de personalidad antisocial, que se diagnostica desde los 18 años con antecedente de trastorno disocial antes de los 15.
- Pesquisar maltrato, abuso, VIF, consumo de sustancias, TDAH, depresión y discapacidad intelectual; evaluar riesgo para terceros y para el propio adolescente.
- Manejo inicial: intervenciones familiares y multisistémicas (familia, colegio, comunidad), activar redes de protección (OPD, Tribunal de Familia) si hay vulneración de derechos.
- Seguimiento: derivar a salud mental infanto-juvenil.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 145

En el servicio de urgencia usted evalúa a un niño de 11 años que se ha comportado muy agresivo, autoagrediéndose y golpeando a su madre. Ella fue citada al colegio por las malas notas y el comportamiento inapropiado de su hijo: el director le informó que había insultado y agredido a sus compañeros y a uno de sus profesores. Tras ser confrontado por su madre, el niño la agredió y luego se infligió cortes en los brazos. Además, su abuela refiere que el niño miente y le ha robado alcohol y cigarrillos de su tienda. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trastorno disocial
B Trastorno de personalidad limítrofe
C Trastorno del espectro autista
D Trastorno por déficit atencional
E Trastorno oposicionista desafiante

Respuesta A. El trastorno disocial es un patrón persistente de violación de los derechos de otros y de normas sociales: agresión a personas, destrucción, engaño o robo. Aquí hay agresión a pares, profesor y madre, mentiras y robos. El oposicionista desafiante no incluye agresión física ni robos, y los trastornos de personalidad no se diagnostican a los 11 años.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 38

Adolescente de 14 años que presenta ausencias repetidas al colegio, peleas con compañeros, robos dentro del hogar y consumo de alcohol desde los 12 años. Los padres refieren que "no respeta ninguna norma". ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Discapacidad intelectual
B TDAH
C Trastorno de conducta
D Trastorno del espectro autista
E Fobia social

Respuesta C. Trastorno de conducta: patrón repetitivo y persistente de comportamiento que viola los derechos básicos de otros o normas sociales (agresión, robo, absentismo, consumo de sustancias). Inicio antes de los 15 años. Requiere intervención multidisciplinaria.

▶ VER CLASE 5.01.1.032 Trastorno somatización en niños

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.2 · Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- En niños la somatización se expresa típicamente con dolor abdominal periumbilical y cefalea recurrentes, ligados a estrés escolar o familiar: aparecen en mañanas de días de colegio y ceden fines de semana y vacaciones.
- Banderas rojas que obligan a estudiar: dolor que despierta, alejado del ombligo, baja de peso, vómitos, sangrado, fiebre recurrente o examen alterado.
- Sin banderas rojas y con examen normal no se piden más exámenes; diferenciar de dolor abdominal funcional, ansiedad de separación, bullying, depresión y abuso.
- Manejo inicial: validar y legitimar el dolor, explicar su origen funcional, abordar los estresores con la familia y el colegio y favorecer el retorno a clases (el ausentismo refuerza el cuadro).
- Seguimiento completo: controles programados con el mismo médico, registro de síntomas y factores gatillantes; derivar a salud mental si persiste, hay deterioro importante o comorbilidad.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niña de 9 años con 4 meses de dolor abdominal periumbilical y cefalea recurrentes, que aparecen en las mañanas de días de colegio y ceden los fines de semana. Ha faltado mucho a clases. Coincide con la separación de sus padres. Crecimiento normal, sin baja de peso, fiebre, sangrado ni despertar nocturno por dolor. Examen físico, hemograma y orina normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Explicar el origen funcional, validar los síntomas y abordar los estresores con la familia y el colegio, favoreciendo el retorno a clases
B Solicitar endoscopía digestiva alta
C Solicitar TAC de abdomen y pelvis
D Indicar reposo en casa hasta que ceda el dolor
E Iniciar benzodiacepinas

Respuesta A. En niños, la somatización se expresa típicamente con dolor abdominal y cefalea recurrentes, ligados a estrés (escuela, conflictos familiares). Sin signos de alarma no se piden más estudios. Se legitima el dolor, se explica su naturaleza, se trabajan los estresores y se promueve la asistencia escolar; el ausentismo refuerza el cuadro.

▶ VER CLASE 5.01.1.033 Trastornos ansiosos en niños

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.18 · Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastornos ansiosos son los más frecuentes en la infancia: ansiedad de separación (miedo excesivo a separarse de los padres, el más frecuente en menores de 12 años), TAG, fobias específicas, fobia social y mutismo selectivo.

- Sospecha: síntomas somáticos (dolor abdominal, cefalea), rechazo escolar, irritabilidad, insomnio, preocupación excesiva por rendimiento o salud de los padres, con deterioro funcional.
- Descartar hipertiroidismo, efectos de fármacos (salbutamol, corticoides), maltrato, bullying y trastornos del ánimo.
- Tratamiento inicial: TCC con participación de la familia es la primera línea; en cuadros moderados a graves o sin respuesta, ISRS (sertralina o fluoxetina), vigilando ideación suicida al inicio.
- Benzodiacepinas no recomendadas de mantención en niños.
- Seguimiento completo: controles de síntomas, asistencia escolar y efectos del ISRS; derivar si es grave, refractario o con comorbilidad.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 7 años, desde hace 3 meses llora intensamente y se queja de dolor de estómago cada vez que debe separarse de su madre para ir al colegio. Teme que a ella le pase algo malo mientras está lejos, no quiere dormir solo y tiene pesadillas sobre perderse. En casa, junto a su madre, juega con normalidad. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trastorno de ansiedad generalizada

B Trastorno de ansiedad social

C Trastorno de ansiedad por separación

D Mutismo selectivo

E Trastorno de pánico

Respuesta C. La ansiedad por separación es miedo excesivo e inapropiado para la edad a separarse de las figuras de apego, con preocupación por que les ocurra algo, rechazo escolar, negativa a dormir solo, pesadillas y síntomas somáticos; en niños dura al menos 4 semanas. Se trata con terapia cognitivo-conductual y trabajo con padres.

▶ VER CLASE 5.01.1.034 **Trastornos del ánimo en niños** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.1 · Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

QUÉ HAY QUE SABER

- En niños y adolescentes la depresión se manifiesta a menudo con irritabilidad, explosiones de rabia, baja del rendimiento escolar, aislamiento, abandono de actividades y quejas somáticas en lugar de tristeza.
- Criterios: los de depresión mayor (≥5 de 9 síntomas por 2 semanas); distimia en niños requiere 1 año. Preguntar siempre por ideación suicida, consumo de sustancias, bullying y abuso.
- Sospechar trastorno bipolar ante antecedentes familiares, episodios de euforia o viraje con antidepresivos.
- Tratamiento inicial: psicoterapia (TCC o interpersonal) y, en cuadros moderados a graves o sin respuesta, fluoxetina (ISRS de elección en adolescentes, garantía GES desde 15 años); tricíclicos no son eficaces y son letales en sobredosis.
- Vigilar ideación suicida al inicio del antidepresivo; mantener 6–12 meses tras la remisión.
- Seguimiento completo: controles frecuentes con la familia y el colegio; derivar si hay riesgo suicida, psicosis, sospecha bipolar o falta de respuesta.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 81

Un adolescente de 16 años presenta, desde hace 3 meses, anhedonia, disminución en su rendimiento escolar y presencia de pensamientos negativos sobre sí mismo y su situación, con aislamiento social. Además, relata dificultades para concentrarse en sus actividades académicas e insomnio tanto de inicio como de mantención. Ha subido 5 kilogramos de peso en los últimos meses. Niega autoagresiones y no tiene ideación suicida actual. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Distimia

B Trastorno del espectro autista

C Episodio depresivo mayor

D Trastorno por déficit atencional

E Trastorno de personalidad

Respuesta C. Cumple criterios de depresión mayor: se afectan el peso, el sueño, el rendimiento escolar y la vida social. En adolescentes la distimia exige un año de ánimo bajo sin cumplir criterios de depresión.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Adolescente de 14 años, desde hace 2 meses está irritable, con explosiones de rabia en casa, ha dejado el fútbol que le gustaba, duerme mal, bajó sus notas y dice que nada vale la pena. Niega ideación suicida. Se diagnostica un episodio depresivo moderado y se decide, junto a la psicoterapia, iniciar un antidepresivo. **¿Cuál es el fármaco de elección?**

A Amitriptilina
B Fluoxetina
C Paroxetina
D Venlafaxina
E Carbonato de litio

Respuesta B. En niños y adolescentes la depresión puede manifestarse con irritabilidad en vez de tristeza. El tratamiento es psicoterapia y, en cuadros moderados a graves, un ISRS, siendo la fluoxetina el de mayor evidencia y de elección según la guía GES. Los tricíclicos no son eficaces y son letales en sobredosis; paroxetina y venlafaxina tienen peor perfil en jóvenes.

▶ VER CLASE 5.01.1.035 Consumo perjudicial de drogas en niños y adolescentes

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.16 · Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

QUÉ HAY QUE SABER

- Consumo perjudicial en adolescentes: uso de alcohol, tabaco, cannabis u otras drogas que ya produce daño (rendimiento escolar, conflictos, conductas de riesgo, accidentes) sin dependencia establecida; el inicio precoz aumenta el riesgo de dependencia y psicosis (cannabis).
- Pesquisa con entrevista confidencial (HEADSSS) y tamizaje (CRAFFT o AUDIT/ASSIST); explorar comorbilidad (depresión, TDAH, ansiedad), riesgo suicida, abuso y contexto familiar.
- Tratamiento: intervención breve y entrevista motivacional, involucrar a la familia, fortalecer factores protectores (escuela, deporte, red de apoyo) y consejería en conductas sexuales de riesgo.
- Garantía GES para consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas en menores de 20 años: plan de tratamiento ambulatorio en APS.
- Confidencialidad con límites: se informa a los padres si hay riesgo vital o para terceros.
- Seguimiento completo: controles para monitorear consumo y metas; derivar a programa especializado si hay dependencia, policonsumo grave o comorbilidad psiquiátrica severa.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Adolescente de 15 años, en su control de salud joven, refiere que fuma marihuana con amigos los fines de semana desde hace 6 meses y que a veces bebe alcohol en fiestas. Usted quiere tamizar el riesgo de consumo problemático con un instrumento validado para su edad. **¿Qué instrumento es el más adecuado?**

A Test de Fagerström
B AUDIT
C CAGE
D CRAFFT
E Minimental

Respuesta D. El CRAFFT es el instrumento de tamizaje validado para consumo de alcohol y drogas en adolescentes; 2 o más respuestas positivas indican riesgo y requieren intervención breve o derivación. El AUDIT y el CAGE fueron diseñados para alcohol en adultos y el Fagerström mide dependencia a la nicotina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 113

¿Cuál es el riesgo principal del consumo de marihuana entre los 12 y los 18 años de edad?

A Riesgo de dependencia a la marihuana
B Riesgo de intoxicación aguda
C Desarrollo de esquizofrenia
D Disminución de la motivación escolar
E Desarrollo de alcoholismo

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Disminución de la motivación escolar). Pregunta difícil.

▶ VER CLASE 5.01.1.036 Trastorno de ansiedad generalizada

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.7 · Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social

QUÉ HAY QUE SABER

- TAG: preocupación excesiva y difícil de controlar por múltiples temas (salud, dinero, familia, trabajo) la mayor parte de los días por ≥6 meses, con ≥3 de 6 síntomas: inquietud, fatiga, dificultad de concentración, irritabilidad, tensión muscular e insomnio.
- Consultan por lo somático (cefalea tensional, contracturas, bruxismo, colon irritable, insomnio); no hay crisis bruscas (eso orienta a pánico).

- Descartar hipertiroidismo (TSH), cafeína, estimulantes, abstinencia y depresión comórbida.
- Tratamiento: ISRS (escitalopram 10–20 mg o sertralina 50–200 mg) o venlafaxina 75–150 mg, más TCC con relajación e higiene del sueño; pregabalina como segunda línea.
- Benzodiacepinas no de mantención (tolerancia, dependencia, alteración de memoria; no tratan la preocupación): como máximo puente breve.
- Seguimiento completo: control a las 2–4 semanas para titular; mantener 6–12 meses tras la respuesta y retirar gradualmente; derivar si es refractario o hay comorbilidad grave.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 104

Una mujer de 30 años se preocupa mucho por las finanzas y la salud de su familia. Además, le angustia que alguno de sus familiares pudiera quedarse sin trabajo o que la economía decayera. Refiere estar pasando por un periodo de estrés laboral y estar estresada porque muchas cosas dependen de ella, tanto en su trabajo, como en su familia. Refiere que en el último tiempo, lo único que la mantiene más tranquila es tomar un poco de clonazepam, el que consume 2 a 3 veces por semana. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trastorno obsesivo compulsivo

B Trastorno de pánico

C Trastorno de personalidad dependiente

D Reacción adversa a las benzodiazepinas

E Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta E. Tiene preocupaciones distintas y de distintos tipos (finanzas, salud de la familia, trabajo): es un trastorno de ansiedad generalizada clásico.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 28 años, egresado de derecho, consulta por ansiedad y contracturas musculares. Hace más de 1 año vive preocupado en exceso: teme no aprobar su examen de grado, que sus padres enfermen, que su auto falle, que sus ahorros no alcancen. Reconoce que es exagerado pero no logra controlarlo. Tiene cefalea tensional frecuente, bruxismo nocturno, fatiga matinal y dificultad para conciliar el sueño. No ha tenido crisis de pánico ni miedo a relacionarse con sus pares. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Clonazepam cada 8 horas de forma indefinida

B ISRS, terapia cognitivo-conductual e higiene del sueño

C Propranolol 40 mg en la mañana todos los días

D Haloperidol en dosis bajas

E Solo reposo y analgésicos para la cefalea

Respuesta B. Trastorno de ansiedad generalizada: preocupación excesiva e incontrolable por varios temas por más de 6 meses, con tensión muscular, fatiga, cefalea e insomnio. Tratamiento de primera línea: ISRS (escitalopram o sertralina), TCC con relajación muscular e higiene del sueño. Las benzodiacepinas crónicas están contraindicadas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 109

Un paciente de 40 años consulta por desasosiego e insomnio de conciliación de 2 meses de evolución. Refiere estar especialmente preocupado por su situación laboral y por el estado de la economía del país. Niega pensamientos suicidas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno adapta2vo

B Trastorno de ansiedad generalizada

C Trastorno de estrés agudo

D Episodio depresivo mayor

E Trastorno de angus2a

Respuesta A. Es un cuadro de ansiedad de solo 2 meses, con un estresante laboral y económico claro, sin criterios de otro trastorno, lo que corresponde a un trastorno adaptativo. El trastorno de ansiedad generalizada exige al menos 6 meses de preocupaciones excesivas en varias áreas, y no hay síntomas depresivos que sugieran un episodio depresivo mayor.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 143

Mujer que ha sido muy aprehensiva con los estudios y preocupada por su familia, pareja y relaciones amorosas, al punto de estar todo el tiempo estresada y con problemas digestivos , ella refiere sentirse asi desde la perdida de su abuelo (que murió hace 5 años), los padres refieren que ha sido asi desde chica:

A Trastorno ansiedad generalizada b. Ts de la personalidad obsesivo compulsivo? (Porque no puede ser esta, considerando que es “una forma de ser” desde muy pequeña?)

B Trastorno de ansiedad generalizada

C Trastorno obsesivo compulsivo

D Trastorno de estrés postraumático

E Episodio depresivo mayor

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Trastorno ansiedad generalizada b. Ts de la personalidad obsesivo compulsivo? (Porque no puede ser esta, considerando que es “una forma de ser” desde muy pequeña?)).

Situaciones clínicas de urgencia

3 códigos

▶ VER CLASE 5.01.2.001 **Conducta suicida** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.3 · Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización

QUÉ HAY QUE SABER

- Factores de riesgo: intento previo (riesgo 30–40 veces), sexo masculino (más suicidios consumados; mujeres más intentos), edad 15–24 o >65 años, viudez, cesantía, aislamiento, depresión, bipolaridad, psicosis, alcohol y enfermedad crónica dolorosa.
- Preguntar directa y escalonadamente: ideación pasiva, ideación activa, plan, acceso al método y actos preparatorios (cartas, regalos); preguntar no induce. Señales de alarma: despedidas, calma súbita tras desesperanza.
- SAD PERSONS orienta: 0–2 ambulatorio con red y control <7 días; 3–4 ambulatorio intensivo con control en 48–72 h; 5–6 psiquiatría urgente; ≥7 hospitalización.
- Hospitalizar si hay intento reciente de mediana/alta letalidad, plan activo y letal, ideación persistente tras la urgencia, psicosis con voces de comando o delirios de culpa, agitación con sustancias o sin red de supervisión.
- En urgencia: tratar lo médico primero (ECG en tricíclicos), vigilancia 1 a 1, retirar cinturones, cordones y fármacos; nunca dar el alta por la promesa de no repetirlo ni sin evaluación psiquiátrica.
- Seguimiento: derivar a psiquiatría; no recetar cajas completas de tricíclicos o benzodiacepinas; litio y clozapina reducen el suicidio en sus indicaciones.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 54 años, viudo hace 4 meses y recién despedido, llevado a urgencias por su cuñado. Lo encontraron en su casa con una botella vacía de pisco, una soga atada a una viga y una carta a sus hijos pidiendo perdón. Está somnoliento, con aliento alcohólico y llanto fácil. Al preguntarle a solas dice: "Apenas salga de aquí voy a terminar lo que empecé". Tuvo un intento por sobredosis hace 12 años. El cuñado pide llevárselo a su casa. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Alta con el cuñado, indicándole reposo y clonazepam

B Rechazar el alta, vigilar 1 a 1 y hospitalizar en psiquiatría

C Sertralina y control en el CESFAM en 7 días

D Alta voluntaria firmada por el paciente

E Lavado gástrico y observación por 2 horas

Respuesta B. Riesgo extremo e inminente: intento previo, viudez, cesantía, alcohol, soga y carta de despedida, y la ideación persiste. Se prohíbe el alta, se vigila 1 a 1, se retiran elementos peligrosos, se maneja la intoxicación alcohólica y se hospitaliza en psiquiatría.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 22 años con trastorno de personalidad límite, ingresada a urgencias tras ingerir 20 comprimidos de paracetamol en un acto impulsivo, después de discutir con su pareja. Se hizo lavado gástrico y se administró N-acetilcisteína. A las 4 horas está tranquila, dice que "fue una tontería" y exige el alta porque tiene que ir a trabajar. Sus padres, agotados, se niegan a recibirla. **¿Cuál es la conducta médica correcta?**

A Alta inmediata con citación abierta a su policlínico

B Hacerla firmar el alta voluntaria y dejar constancia en la ficha

C Mantener en observación protegida, completar el tratamiento con N-acetilcisteína y asegurar la evaluación psiquiátrica antes del alta

D Administrar haloperidol intramuscular para controlar la conducta

E Indicar reposo en la sala de espera sin vigilancia

Respuesta C. Todo intento de suicidio, sea cual sea el diagnóstico de base, exige observación protegida hasta completar el manejo toxicológico y una evaluación psiquiátrica. Que no tenga red familiar que la reciba refuerza que no se puede dar el alta inmediata.

▶ VER CLASE 5.01.2.002 **Agitación psicomotora** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.14 · Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada

QUÉ HAY QUE SABER

- Agitación psicomotora: síndrome, no diagnóstico; primero descartar causa orgánica (delirium): glicemia capilar, saturación, signos vitales, TEC, ACV, infección, retención urinaria, intoxicación o abstinencia.
- Orgánica: conciencia fluctuante, desorientación, alucinaciones visuales, signos vitales alterados; psiquiátrica: vigil y orientado, alucinaciones auditivas, antecedentes (manía, esquizofrenia, personalidad límite).
- Manejo escalonado: 1) seguridad (nunca solo, salida libre) y contención verbal; 2) farmacológica oral si colabora (lorazepam 2 mg, risperidona 2 mg u olanzapina 10 mg); 3) IM: haloperidol 5 mg + lorazepam 2 mg.
- Prohibido olanzapina IM junto con benzodiacepina parenteral (colapso cardiorrespiratorio). En adulto mayor con delirium: haloperidol 0,5–1 mg o quetiapina 25 mg, sin benzodiacepinas.
- Contención física de 4 puntos solo como último recurso, con orden médica escrita (Ley 21.331), decúbito supino con cabecera a 30–45°, control de signos vitales y perfusión cada 15–30 minutos y retiro progresivo.
- Seguimiento: derivar a psiquiatría o al especialista según la causa una vez estabilizado.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 8

Un paciente de 25 años, con esquizofrenia, recibe 5 mg de haloperidol intramuscular, por un cuadro de agitación psicomotora. A las dos horas presenta contracción tónica y dolorosa del cuello, con desviación hacia la derecha. ¿Cuál es el tratamiento de este cuadro? **¿Cuál es el tratamiento de este cuadro?**

A Bromocriptina
B Clorpromazina
C Lorazepam
D Diclofenaco
E Propranolol

Respuesta C. El manejo de la distonía aguda (tortícolis espasmódica) es suspender el antipsicótico y administrar una benzodiacepina. El biperideno es el anticolinérgico de elección, pero no figura entre las alternativas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 30

Un paciente de 39 años es detenido, porque estaba haciendo disturbios en la vía pública. Es llevado para constatar lesiones y, al examen no coopera y se muestra angustiado y agitado, con agresión verbal hacia el personal de salud, sin llegar a la agresión física. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Administrar haloperidol 5 mg intramuscular
B Risperidona 1 mg vía oral
C Diazepam 5 mg intramucular
D Contención verbal
E Contención física

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Contención física (opción E).

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 130

Paciente ingresado con agitación, agresión verbal y movimientos inquietos de manos y pies. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A Haloperidol 5 mg IM inmediato
B Contención verbal y ambiental
C Lorazepam 2 mg IM
D Contención física
E Olanzapina 10 mg IM

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Contención verbal y ambiental (opción B). Contención verbal y ambiental.

▶ VER CLASE 5.01.2.003 Intoxicación por sustancias psicoactivas

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.16 · Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

QUÉ HAY QUE SABER

- Simpaticomimético (cocaína, pasta base, anfetaminas): taquicardia, HTA, hipertermia, midriasis, diaforesis, agitación y psicosis; complicaciones IAM por vasoespasmo, ACV, disección aórtica y rabdomiólisis.
- Opioide: miosis puntiforme, bradipnea y coma (naloxona EV); sedante-hipnótico (benzodiacepinas): sopor, ataxia, disartria con signos vitales estables; anticolinérgico: midriasis, piel seca y roja, hipertermia, delirium.
- Dolor torácico por cocaína: benzodiacepinas EV (diazepam 5–10 mg o lorazepam 2–4 mg), AAS y nitroglicerina; betabloqueadores contraindicados (estímulo alfa sin oposición).
- Benzodiacepinas: soporte; flumazenil contraindicado en usuarios crónicos o coingesta de tricíclicos (convulsiones). Alcohol: tiamina antes de glucosa. Cannabis: ansiedad o psicosis aguda; hiperemesis cannabinoide en consumo crónico.
- Medidas generales: ABC, glicemia capilar, ECG, CPK y electrolitos; contención de la agitación con benzodiacepinas; evaluar intencionalidad (intento suicida).
- Seguimiento: derivar a toxicología o UPC si es grave y, una vez estabilizado, a programa de tratamiento de consumo.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 126

Paciente usuaria de litio en sopor profundo, litemia de 2,6 mEq/L. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Lavado gástrico y carbón activado
B Solución salina 0,9% endovenosa
C Suspender litio y observar
D Diuresis forzada con furosemida
E Hemodiálisis de urgencia

Respuesta E. Intoxicación por litio con neurotoxicidad grave (sopor profundo): criterio I de AEIOU. El litio es pequeño, poco unido a proteínas y muy dializable. El carbón activado no une el litio.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 120

Un paciente de 20 años, con diagnóstico de trastorno bipolar, en tratamiento con risperidona y litio, desde hace 3 meses, consulta por un cuadro de una semana de evolución de náuseas, malestar general y tendencia al sopor. Al examen físico se constata desorientado, con temblor de extremidades superiores. Se solicitan exámenes, entre los que destaca litemia de 2,2 mEq/L (rango normal: 0,6 a 1,2 mEq/L) y creatininemia: 1,3 mg/dl. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada? **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Plasmaféresis
B Hemodiálisis
C Alcalinizar la orina
D Administrar suero fisiológico endovenoso
E Diazepam endovenoso

Respuesta D. Intoxicación moderada por litio (litemia 2,2, temblor, desorientación). Se suspende el litio y se hidrata con suero fisiológico endovenoso. La hemodiálisis se reserva para formas graves.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 69

Un hombre encuentra a su pareja en su casa desorientada y con una actitud agresiva y agitada, por lo que la lleva al servicio de urgencia. Al examen físico presenta sudoración profusa y sus signos vitales muestran presión arterial 170/110 mmHg, frecuencia cardíaca 160 por minuto y temperatura 38,1 °C. En el examen neurológico se aprecia desorientada en tiempo y espacio, con agitación psicomotora y pupilas midriáticas isocóricas. ¿Qué sustancia ingirió con mayor probabilidad?

A Barbitúricos
B Canabinoides
C Anfetaminas
D Órganofosforados
E Opiáceos

Respuesta C. Tiene un síndrome adrenérgico: midriasis, taquicardia, hipertensión, agitación, hipertermia. La cocaína y las anfetaminas son las clásicas causas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 18

Un paciente de 23 años, con retraso mental severo, en tratamiento con clorpromacina, sube la dosis de este medicamente de 100 a 300 mg al día, evolucionando con agitación psicomotora, confusión, boca seca, palpitaciones y malestar general. Su examen físico muestra FC: 115x', PA: 130/90 mmHg, pupilas con midriasis. El diagnóstico más probable es un síndrome:

A Anticolinérgico
B Adrenérgico
C Serotoninérgico
D Colinérgico
E Neuroléptico maligno

Respuesta A. Los antipsicóticos producen 1. Síndrome neuroléptico maligno y 2. Síndrome anticolinérgico. Las clínicas de todos estos síndromes se preguntan y están descritas en la clase respectiva de intoxicaciones (psiquiatría). En este caso es un síndrome anticolinérgico clásico.

Conocimientos generales

13 códigos

▶ VER CLASE **5.01.3.001** **Clasificaciones en psiquiatría**

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.19 · Psiquiatría General: Clasificaciones (DSM-5/CIE-10), Higiene del Sueño, Trastornos Facticios y Nociones de Psiquiatría Forense

QUÉ HAY QUE SABER

- Dos sistemas de clasificación: DSM-5 (Asociación Americana de Psiquiatría), con criterios operacionales por categorías y sin el sistema multiaxial anterior, y CIE (OMS; CIE-10 en uso para estadísticas y GES en Chile, CIE-11 vigente internacionalmente).
- Se basan en criterios clínicos descriptivos (síntomas, duración, deterioro y exclusión de causa médica o sustancias), no en etiología, lo que permite un diagnóstico confiable entre clínicos.
- Grandes grupos: trastornos del neurodesarrollo, espectro esquizofrénico y psicóticos, bipolares, depresivos, de ansiedad, obsesivo-compulsivos, relacionados con trauma, disociativos, de síntomas somáticos, alimentarios, del sueño, por sustancias, neurocognitivos y de la personalidad.
- Cambios relevantes del DSM-5: TEA reúne los antiguos trastornos generalizados del desarrollo; TOC y TEPT salen de los trastornos de ansiedad; 'trastorno neurocognitivo mayor/menor' reemplaza a demencia y deterioro leve.
- La duración es clave en muchos diagnósticos: estrés agudo <1 mes vs TEPT; psicosis breve <1 mes, esquizofreniforme 1–6 meses, esquizofrenia ≥6 meses; distimia ≥2 años.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un médico de un CESFAM debe registrar el diagnóstico de un paciente con depresión para efectos estadísticos, de licencia médica y de notificación GES, según el sistema oficial usado por el Ministerio de Salud de Chile. **¿Qué sistema de clasificación corresponde utilizar?**

A Escala de depresión de Hamilton

B Manual Diagnóstico y Estadístico DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría

C Escala de Evaluación de la Actividad Global (GAF)

D Clasificación de Kraepelin

E Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la OMS

Respuesta E. En Chile, las estadísticas oficiales, licencias médicas y registros del sistema de salud usan la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la OMS. El DSM-5, de la Asociación Americana de Psiquiatría, es muy usado en clínica e investigación, y abandonó el sistema multiaxial. Las escalas GAF y Hamilton miden gravedad, no clasifican.

▶ VER CLASE 5.01.3.002 Conducta suicida

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.3 · Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización

QUÉ HAY QUE SABER

- En Chile la mortalidad por suicidio ronda 10 por 100.000 habitantes; las mujeres intentan 3–4 veces más y los hombres consuman 4–5 veces más. Casi siempre hay un trastorno mental de base (depresión, bipolar, psicosis, alcohol).
- Factores de riesgo: intento previo (el más potente), sexo masculino, edades extremas (15–24 y >65 años), viudez, cesantía, aislamiento, enfermedad crónica dolorosa, impulsividad, acceso a medios letales.
- Factores protectores: red de apoyo, hijos a cargo, empleo, creencias, adherencia y alianza terapéutica, habilidades de resolución de problemas.
- Mitos: preguntar no induce el suicidio; quien se quiere suicidar suele avisar; una mejoría súbita puede ser el momento de mayor riesgo.
- Prevención (Programa Nacional de Prevención del Suicidio): detección y tratamiento de la depresión en APS, restricción de medios letales, capacitación de gatekeepers, seguimiento tras intentos y manejo responsable en medios de comunicación.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En un control de atención primaria, un médico sospecha que una paciente de 42 años con depresión mayor moderada podría estar pensando en suicidarse, pero duda si preguntárselo por temor a que la pregunta actúe como estímulo o aumente su angustia. **¿Cuál es la afirmación correcta?**

A No se debe preguntar; es mejor esperar a que ella mencione el tema

B Preguntar directamente es necesario, no induce la conducta suicida y suele aliviar a la paciente

C Solo un psiquiatra puede interrogar sobre ideas de muerte

D Indagar sobre el método está contraindicado porque enseña alternativas letales

E La pregunta solo debe hacerse en presencia de Carabineros

Respuesta B. Preguntar de forma respetuosa y directa no induce el suicidio: disminuye la angustia, rompe el aislamiento y es la única forma de medir el riesgo y proteger. Preguntar por el método y el plan es parte de la evaluación.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 28 años con esquizofrenia paranoide, con dos intentos suicidas impulsivos de alta letalidad en el último año a pesar de risperidona 6 mg al día. Está clínicamente estable, con suspicacia residual. **¿Qué psicofármaco ha demostrado reducir la conducta suicida en la esquizofrenia?**

A Haloperidol

B Clozapina

C Clorpromazina

D Alprazolam

E Sertralina

Respuesta B. La clozapina es el único antipsicótico con indicación formal para reducir la conducta suicida recurrente en esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo. En los trastornos del ánimo, el equivalente es el litio.

▶ VER CLASE 5.01.3.003 Desarrollo cognitivo, afectivo y social a lo largo del ciclo vital

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.2 · Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Piaget (cognitivo): sensoriomotor 0–2 años (permanencia del objeto), preoperacional 2–7 (egocentrismo, animismo, pensamiento mágico), operaciones concretas 7–11 (conservación, lógica concreta) y operaciones formales desde los 12 (pensamiento abstracto).
- Erikson (psicosocial): confianza vs desconfianza (lactante), autonomía vs vergüenza, iniciativa vs culpa, laboriosidad vs inferioridad (escolar), identidad vs confusión (adolescente), intimidad vs aislamiento, generatividad vs estancamiento e integridad vs desesperación (vejez).
- Apego (Bowlby): vínculo seguro con el cuidador como base del desarrollo afectivo; ansiedad ante extraños hacia los 8 meses y de separación entre 8–18 meses.

- Hitos: sonrisa social a los 2–3 meses, sostén cefálico a los 3 meses, sedestación sin apoyo a los 8–9 meses, marcha independiente a los 12 meses (límite 18), frases de 2 palabras a los 24 meses; la regresión de habilidades es siempre alarma.
- Evaluación en Chile: EEDP de 0–24 meses (controles de 8 y 18 meses) y TEPSI de 2–5 años (control de 3 años); ≥85 normal, 70–84 riesgo (estimulación), <70 retraso (derivar); edad corregida en prematuros hasta los 2 años.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niña de 4 años, con desarrollo normal. Su madre cuenta que cree que la luna la sigue cuando van en auto, que sus muñecas sienten frío y que, si ella cierra los ojos, nadie puede verla. **Según Piaget, ¿en qué etapa del desarrollo cognitivo se encuentra?**

A Sensoriomotora
B Operaciones concretas
C Preoperacional
D Operaciones formales
E Latencia

Respuesta C. La etapa preoperacional de Piaget, aproximadamente de 2 a 7 años, se caracteriza por pensamiento simbólico, egocentrismo, animismo (atribuir vida a objetos) y pensamiento mágico, sin lógica de conservación. La sensoriomotora va de 0 a 2 años, las operaciones concretas de 7 a 11 y las formales desde los 12. La latencia es una etapa de Freud.

▶ VER CLASE 5.01.3.004 Higiene de la alimentación

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.4 · Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)

QUÉ HAY QUE SABER

- Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementada hasta los 2 años o más; contraindicaciones: VIH, HTLV, TBC bacilífera activa, drogas ilícitas o quimioterapia materna, galactosemia del lactante.
- Suplementación: vitamina D 400 UI/día desde el mes hasta el año; hierro 1 mg/kg/día desde los 4 meses en término (2–3 mg/kg/día desde los 2 meses en prematuros o bajo peso).
- Alimentación complementaria: primera comida (almuerzo) a los 6 meses con aceite vegetal crudo, segunda (cena) a los 8–9 meses; prohibidos el primer año la miel (botulismo), la sal, el azúcar y la leche de vaca entera.
- Higiene de la alimentación familiar: horarios regulares, comer en familia y sin pantallas, ofrecer variedad repetidamente, respetar la saciedad y no usar alimentos como premio o castigo.
- Prevención de la malnutrición por exceso: evitar bebidas azucaradas y ultraprocesados (rotulado 'ALTO EN' de la Ley de Etiquetado), fomentar frutas, verduras, agua y actividad física; los hábitos rígidos o el forzar se asocian a selectividad y TCA.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Madre de un niño sano de 4 años, con peso y talla normales, consulta porque es mañoso para comer. Para que coma le promete postre como premio, lo deja comer frente a la televisión y, si no termina el plato, le prepara otra comida. **¿Cuál es la recomendación más adecuada?**

A Comidas en familia en horarios regulares, sin pantallas, sin usar alimentos como premio o castigo, respetando su saciedad
B Obligarlo a terminar el plato en cada comida
C Indicar suplementos nutricionales
D Permitir colaciones libres durante el día para asegurar la ingesta
E Ofrecerle solo los alimentos que acepta

Respuesta A. La higiene de la alimentación busca hábitos saludables y una relación sana con la comida: horarios regulares, comer en familia, sin pantallas, ofrecer variedad repetidamente y respetar la saciedad. Usar la comida como premio, forzar o preparar menús alternativos refuerza la selectividad y se asocia a malnutrición por exceso y conductas alimentarias alteradas.

▶ VER CLASE 5.01.3.005 Higiene del sueño

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.19 · Psiquiatría General: Clasificaciones (DSM-5/CIE-10), Higiene del Sueño, Trastornos Facticios y Nociones de Psiquiatría Forense

QUÉ HAY QUE SABER

- Higiene del sueño: horarios regulares de acostarse y levantarse (también fines de semana), habitación oscura, silenciosa y templada, y exposición a luz natural en la mañana.
- Evitar cafeína y bebidas energéticas en la tarde, alcohol y nicotina de noche, comidas abundantes antes de dormir y ejercicio intenso en las 2–3 horas previas; el ejercicio regular diurno ayuda.
- Evitar pantallas al menos 1 hora antes de dormir y siestas largas (>30 minutos) o tardías.
- Control de estímulos: usar la cama solo para dormir; si no concilia en ~20 minutos, levantarse a una actividad tranquila y volver con sueño.
- Insomnio crónico: la TCC para insomnio es la primera línea; evitar benzodiacepinas e hipnóticos de uso prolongado (tolerancia, dependencia, caídas en adultos mayores) y buscar causas como depresión, ansiedad, apnea del sueño, dolor o fármacos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 94

Enfermera que, luego de sus turnos de urgencia, tiene dificultad para dormir y se automedica con diazepam. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Clotiazepam antes de dormir

B Quetiapina

C Higiene del sueño y control ambiental

D Zolpidem

E Observación clínica

Respuesta C. El insomnio por trabajo en turnos se maneja primero con medidas no farmacológicas: higiene del sueño, oscuridad y silencio al dormir de día, horarios regulares, evitar cafeína y pantallas. Se debe suspender la automedicación con benzodiacepinas por riesgo de tolerancia y dependencia; cambiarla por otra benzodiacepina, un hipnótico Z o quetiapina no resuelve el problema.

▶ VER CLASE 5.01.3.006 Disforia de género

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.20 · Sexualidad Humana: Respuesta Sexual, Disfunciones Sexuales, Parafilias, Disforia de Género y Diversidad

QUÉ HAY QUE SABER

- Disforia de género: incongruencia marcada entre el género experimentado y el asignado al nacer, por ≥6 meses, con malestar o deterioro significativo; la identidad trans o no binaria por sí misma no es enfermedad (CIE-11 la ubica como 'incongruencia de género' fuera de los trastornos mentales).
- Abordaje con escucha respetuosa, uso del nombre y pronombres elegidos y confidencialidad; evaluar salud mental (depresión, ansiedad, riesgo suicida aumentado por discriminación y bullying) y red de apoyo.
- En Chile la Ley 21.120 de identidad de género permite la rectificación registral de nombre y sexo (desde los 14 años con representantes y procedimiento judicial; trámite administrativo en mayores de 18).
- Niños y adolescentes: acompañamiento psicosocial y familiar por equipos especializados; las intervenciones hormonales (bloqueo puberal, hormonas cruzadas) son decisiones de especialistas.
- Las llamadas terapias de conversión están contraindicadas; derivar a equipos de identidad de género para acompañamiento integral.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Adolescente de 15 años, asignado hombre al nacer, consulta con su madre. Desde hace más de 2 años se identifica de manera persistente como mujer, siente intenso malestar con sus caracteres sexuales secundarios y ha bajado su rendimiento escolar. Su madre la apoya. Niega ideación suicida. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar una terapia orientada a cambiar su identidad de género

B Derivar a evaluación especializada multidisciplinaria, con acompañamiento psicosocial y evaluación de salud mental

C Iniciar estrógenos en atención primaria

D Esperar que la situación se resuelva con la madurez

E Iniciar antipsicóticos por sospecha de delirio

Respuesta B. La incongruencia de género no es una enfermedad mental; la disforia de género alude al malestar asociado. Corresponde acompañamiento respetuoso y derivación a un equipo especializado multidisciplinario (en Chile, programa de acompañamiento de identidad de género), evaluando comorbilidad como depresión o riesgo suicida. Las terapias de conversión son dañinas y la terapia hormonal requiere evaluación especializada.

▶ VER CLASE 5.01.3.007 Maltrato en el adulto mayor

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.22 · Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Maltrato a personas mayores: físico, psicológico, sexual, financiero o patrimonial, negligencia (del cuidador o autonegligencia) y abandono; con frecuencia el agresor es un familiar cuidador con sobrecarga.
- Factores de riesgo: dependencia funcional, demencia, aislamiento social, cuidador único con sobrecarga, consumo de alcohol o patología mental del cuidador, conflictos familiares.
- Señales: hematomas en distintas etapas, lesiones inexplicadas, desnutrición, deshidratación, mala higiene, úlceras por presión, retraso en consultar, cuidador controlador que no deja hablar al paciente, cambios en el manejo del dinero.
- Conducta: entrevistar a la persona mayor a solas, registrar detalladamente las lesiones en la ficha, evaluar riesgo y activar la red de protección (SENAMA, Tribunal de Familia); el maltrato a personas mayores constituye violencia intrafamiliar según la Ley 20.066 y debe denunciarse.
- Prevención: apoyo y respiro al cuidador (escala de Zarit), programas de cuidados domiciliarios y promoción del buen trato.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 82 años, con demencia moderada, vive con su hijo, que es su único cuidador. Consulta por una caída. Al examen tiene hematomas en distintas etapas de evolución en ambos brazos, baja de peso y mala higiene. El hijo responde todas las preguntas por ella y se niega a dejarla sola con el equipo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Entrevistarla a solas, registrar detalladamente las lesiones, activar la red de protección y realizar la denuncia

B Atribuir los hematomas a fragilidad capilar propia de la edad

C Indicar control en 3 meses

D Pedir explicaciones al hijo y dar el alta si son coherentes

E Solicitar pruebas de coagulación y no tomar otras medidas

Respuesta A. Hematomas en distintas etapas, desnutrición, mala higiene y un cuidador controlador son señales de maltrato y negligencia. Se debe entrevistar a la persona mayor a solas, documentar en la ficha, evaluar riesgo y activar la red de protección, con denuncia, ya que el maltrato a personas mayores es violencia intrafamiliar según la ley chilena.

▶ VER CLASE 5.01.3.008 Maltrato infantil

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.13 · Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

QUÉ HAY QUE SABER

- Tipos: maltrato físico, psicológico, sexual, negligencia (alimentación, salud, educación, supervisión) y abandono; incluye el síndrome del niño sacudido y el facticio por poderes.
- Sospechar ante mecanismo incoherente con la lesión o la edad, consulta tardía, lesiones en distintas etapas, fracturas en niños que no deambulan (espiroidea de fémur, costales posteriores, metafisarias), quemaduras en guante o calcetín, hematomas en zonas no expuestas, hemorragias retinianas.
- Abuso sexual: el relato del niño se registra textualmente, sin interrogatorios repetidos; la ausencia de lesiones no lo descarta.
- Conducta: proteger al niño (hospitalizar si el riesgo persiste), estudio de lesiones ocultas (serie ósea, fondo de ojo, neuroimagen en lactantes), registro detallado y denuncia dentro de 24 horas (Fiscalía, Carabineros o PDI) además de medida de protección en Tribunal de Familia u OPD.
- Prevención: visitas domiciliarias y apoyo a la crianza (Chile Crece Contigo), detección de factores de riesgo familiares (VIF, consumo, depresión materna) y crianza respetuosa sin castigo físico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 4 meses es traído a urgencia por llanto e inmovilidad de la pierna derecha. Los padres refieren que se cayó del sofá hace 2 días. La radiografía muestra una fractura espiroidea de fémur. El lactante aún no logra girarse solo y tiene equimosis en el tórax. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Hospitalizar para protección y estudio (serie ósea y fondo de ojo), registrar los hallazgos y denunciar

B Inmovilizar y dar de alta con control en traumatología

C Dar de alta y citar a control en una semana

D Realizar la denuncia y dar de alta con los padres

E Descartar osteogénesis imperfecta antes de adoptar cualquier medida

Respuesta A. Fractura de fémur en un lactante que no se desplaza, con mecanismo incoherente, consulta tardía y equimosis, es altamente sugerente de maltrato. Se hospitaliza para protegerlo y estudiarlo (serie ósea, fondo de ojo, eventual neuroimagen), se registra en la ficha y se denuncia, deber legal del médico. El estudio de diagnósticos diferenciales no retrasa la protección.

▶ VER CLASE 5.01.3.009 Nociones de psiquiatría forense

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.19 · Psiquiatría General: Clasificaciones (DSM-5/CIE-10), Higiene del Sueño, Trastornos Facticios y Nociones de Psiquiatría Forense

QUÉ HAY QUE SABER

- Imputabilidad: el Código Penal exime de responsabilidad al que por enfermedad mental grave (psicosis activa, discapacidad intelectual grave) no puede comprender la ilicitud del acto o autodeterminarse; la determina el peritaje psiquiátrico forense (Servicio Médico Legal) a solicitud del tribunal.
- Capacidad civil: la interdicción por demencia la declara un juez con informe médico; la capacidad para consentir un tratamiento se evalúa caso a caso (comprender, apreciar, razonar y expresar una decisión).
- Hospitalización involuntaria (Ley 21.331): excepcional, solo con riesgo grave e inminente para sí o terceros por un trastorno mental, cuando no hay alternativa menos restrictiva; requiere indicación médica fundada, registro y comunicación a la autoridad sanitaria y a la comisión de protección.
- Secreto profesional: se mantiene salvo riesgo grave para el paciente o terceros y en el deber de denuncia de delitos (lesiones, abuso sexual, maltrato), que el equipo de salud debe cumplir dentro de 24 horas.
- Muertes violentas o sospechosas (suicidio, intoxicación) son médico-legales: el clínico no firma el certificado y se notifica para autopsia en el Servicio Médico Legal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 28 años con esquizofrenia, sin tratamiento hace 6 meses, agrede gravemente a su vecino. En el peritaje se constata que al momento del hecho cursaba un episodio psicótico agudo, con delirio de persecución en el que el vecino lo iba a matar, y alucinaciones auditivas que le ordenaban defenderse. **¿Qué concepto pericial corresponde a su condición al momento del delito?**

A Simulación

B Inimputabilidad por enajenación mental

C Imputabilidad plena

D Trastorno facticio

E Responsabilidad penal agravada por la enfermedad

Respuesta B. La imputabilidad es la capacidad de comprender la ilicitud de un acto y autodeterminarse según esa comprensión. Un episodio psicótico agudo que priva totalmente de razón al momento del hecho determina inimputabilidad (Código Penal, loco o demente). No exime de consecuencias: el tribunal puede imponer medidas de seguridad, como internación o tratamiento.

▶ VER CLASE 5.01.3.010 Personalidad: Concepto y medición. Principales teorías en psicología de la personalidad

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.17 · Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C

QUÉ HAY QUE SABER

- Personalidad: patrón relativamente estable de pensar, sentir y comportarse que caracteriza a la persona; resulta de la interacción entre temperamento (base biológica y heredable) y carácter (aprendido en el desarrollo).
- Teorías: psicoanalítica de Freud (ello, yo, superyó; mecanismos de defensa), psicosocial de Erikson (etapas a lo largo del ciclo vital), modelo de rasgos de cinco factores (neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad, responsabilidad) y modelo de Cloninger (temperamento y carácter).
- Mecanismos de defensa: maduros (sublimación, humor, altruismo), neuróticos (represión, desplazamiento, formación reactiva) e inmaduros (proyección, escisión, negación, acting out), típicos estos últimos del trastorno límite.
- Medición: entrevista clínica, cuestionarios estructurados (MMPI-2, inventarios de cinco factores) y pruebas proyectivas (Rorschach, TAT).
- El trastorno de personalidad se define cuando los rasgos son inflexibles y desadaptativos, se inician en la adolescencia o adultez temprana, son estables y causan deterioro; se agrupan en clústeres A, B y C.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En una clase sobre personalidad se explica que esta resulta de la interacción de dos componentes: uno de base biológica, heredable, presente desde los primeros meses de vida y relativamente estable, y otro adquirido por aprendizaje, cultura y experiencias. **¿Cómo se denomina el componente biológico y heredable de la personalidad?**

A Rasgo patológico

B Carácter

C Mecanismo de defensa

D Estado de ánimo

E Temperamento

Respuesta E. La personalidad integra temperamento y carácter. El temperamento es la base constitucional, heredable y observable desde la infancia (por ejemplo, reactividad o búsqueda de novedad, según Cloninger). El carácter se moldea por el aprendizaje y el entorno. Los rasgos de personalidad se evalúan con instrumentos como el MMPI o el modelo de los cinco grandes factores.

▶ VER CLASE 5.01.3.011 Prevención: Alcohol, tabaco, drogas. Modelo de prevención primaria.

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.16 · Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

QUÉ HAY QUE SABER

- Prevención primaria: evitar el inicio o retrasar la edad de inicio del consumo; puede ser universal (toda la población), selectiva (grupos de riesgo) o indicada (personas con consumo inicial o señales de riesgo).
- Factores de riesgo: inicio precoz, consumo en la familia o pares, baja percepción de riesgo, fácil acceso, deserción escolar, maltrato y trastornos mentales (TDAH, depresión); protectores: vínculo familiar, supervisión parental, escuela y actividades prosociales.
- Estrategias poblacionales con evidencia: regulación de precio, disponibilidad y publicidad del alcohol y tabaco, ambientes libres de humo, control de venta a menores y controles de alcoholemia en conductores (Ley de tolerancia cero).
- Programas de SENDA en establecimientos educacionales y comunidad, fortalecimiento de habilidades parentales y sociales; en APS, tamizaje (AUDIT, ASSIST, Fagerström) e intervención breve.
- Tabaco: consejería breve en cada consulta (modelo de las 5A), terapias de apoyo a la cesación (sustitución de nicotina, bupropión, vareniclina).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una comuna implementa en todos sus colegios, desde quinto básico, un programa de desarrollo de habilidades socioemocionales y de información sobre alcohol y drogas, dirigido a todos los estudiantes, la mayoría de los cuales nunca ha consumido. **¿A qué tipo de prevención corresponde esta estrategia?**

A Prevención secundaria

B Prevención primaria indicada

C Prevención primaria universal

D Prevención terciaria

E Reducción de daños

Respuesta C. La prevención primaria busca evitar o retrasar el inicio del consumo. Es universal cuando se dirige a toda una población sin seleccionar por riesgo, como un programa escolar; selectiva si apunta a grupos de riesgo, e indicada si se dirige a personas con consumo inicial o señales tempranas. La detección y tratamiento precoz es prevención secundaria.

▶ VER CLASE 5.01.3.012 Respuesta sexual humana

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.20 · Sexualidad Humana: Respuesta Sexual, Disfunciones Sexuales, Parafilias, Disforia de Género y Diversidad

QUÉ HAY QUE SABER

- Modelo de Masters y Johnson: cuatro fases de la respuesta sexual: excitación, meseta, orgasmo y resolución; el hombre presenta un período refractario tras el orgasmo, la mujer puede ser multiorgásmica.
- Kaplan agregó la fase de deseo previa a la excitación (modelo trifásico: deseo, excitación, orgasmo); el modelo circular de Basson describe en mujeres un deseo frecuentemente responsivo, motivado por la intimidad.
- Fisiología: excitación mediada por el parasimpático (erección, lubricación vaginal por vasocongestión, mediada por óxido nítrico) y eyaculación/orgasmo por el simpático (emisión) y reflejo somático (expulsión).
- Cada fase puede alterarse y origina las disfunciones sexuales (deseo hipoactivo, disfunción eréctil, anorgasmia, eyaculación precoz); influyen la edad, enfermedades crónicas, fármacos (ISRS, antihipertensivos) y factores psicológicos y de pareja.
- Con la edad la respuesta se enlentece (erección más lenta, menor lubricación por hipoestrogenismo), pero la actividad sexual se mantiene y debe abordarse en la consulta del adulto mayor.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En una clase sobre el modelo de respuesta sexual humana de Masters y Johnson se describen cuatro fases sucesivas: excitación, meseta, orgasmo y resolución. **¿En qué fase aparece el período refractario masculino, durante el cual no es posible un nuevo orgasmo?**

A Excitación

B Meseta

C Orgasmo

D Resolución

E Deseo

Respuesta D. Según Masters y Johnson, tras el orgasmo viene la resolución, en que el organismo vuelve al estado basal; en el hombre incluye un período refractario, que se prolonga con la edad. La mujer puede tener orgasmos múltiples sin período refractario. La fase de deseo fue incorporada después por Kaplan y no es parte del modelo original.

▶ VER CLASE 5.01.3.013 Violencia intrafamiliar

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.13 · Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

QUÉ HAY QUE SABER

- Violencia intrafamiliar (Ley 20.066): todo maltrato que afecte la vida o integridad física o psíquica de quien es o ha sido cónyuge o conviviente, pariente, o persona menor de edad, mayor o con discapacidad bajo cuidado del grupo familiar; incluye violencia física, psicológica, sexual y económica.
- Detección: preguntar en forma rutinaria y a solas ante lesiones inexplicadas, consultas reiteradas, síntomas somáticos, depresión, embarazo con control tardío o pareja controladora.
- Conducta: tratar las lesiones, evaluar el riesgo (amenaza con armas, escalada, temor por su vida, femicidio frustrado), registrar en la ficha, denunciar (Fiscalía, Carabineros, PDI o Tribunal de Familia) y activar la red (Centros de la Mujer de SernamEG, casas de acogida).
- El deber de denuncia de lesiones por delito rige para el equipo de salud dentro de 24 horas; la terapia de pareja está contraindicada mientras exista violencia.
- Prevención: educación en relaciones igualitarias desde la escuela, detección precoz en APS y en el control prenatal, y protección de niños expuestos (también son víctimas).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 35 años consulta en el servicio de urgencia de un hospital público por contusiones en la cara y los brazos. Relata que su pareja la golpea hace un año, que anoche la amenazó con un cuchillo y que teme por su vida. Tiene 2 hijos pequeños en casa. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Recomendar terapia de pareja

B Tratar las lesiones, evaluar el riesgo, registrar en la ficha, realizar la denuncia y activar la red de protección

C Tratar las lesiones y dar de alta sin registrar para proteger su privacidad

D Citar a la pareja para conversar con ambos

E Derivar a psicología con hora en 3 meses

Respuesta B. Ante violencia intrafamiliar se atiende la lesión, se evalúa el riesgo (amenaza con arma y temor por su vida son de alto riesgo), se registra en la ficha y se activa la red de protección. En un establecimiento público el médico tiene deber de denuncia de lesiones por delito. La terapia de pareja está contraindicada en violencia activa.

Exámenes e imagenología

4 códigos

▶ VER CLASE 5.01.4.001 **Estudio de hormonas tiroídeas** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.6 · Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS

QUÉ HAY QUE SABER

- Ante todo cuadro depresivo o ansioso nuevo se debe descartar disfunción tiroidea: la TSH es el mejor examen único de tamizaje.
- Hipotiroidismo: TSH alta con T4 libre baja; simula depresión (fatiga, bradipsiquia, aumento de peso, constipación, intolerancia al frío) y puede causar deterioro cognitivo reversible.
- Hipertiroidismo: TSH suprimida con T4 libre alta; simula ansiedad o pánico (palpitaciones, temblor, baja de peso, insomnio, intolerancia al calor) y puede desencadenar manía.
- Hipotiroidismo subclínico (TSH alta con T4 libre normal) puede empeorar la respuesta a antidepresivos; el litio produce hipotiroidismo y bocio: TSH basal y cada 6–12 meses durante el tratamiento.
- Tras confirmar disfunción, tratar la causa tiroidea antes de atribuir los síntomas a un trastorno psiquiátrico primario.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 161

Un paciente de 30 años, sin antecedentes, consulta por fatigabilidad asociada a disminución de peso desde hace tres meses. Al entrevistarlo de forma dirigida refiere que hace tres meses tuvo una ruptura sentimental, por lo que desde entonces además de los síntomas mencionados ha estado con pena, insomnio y desconcentración. Su examen físico resulta normal y su índice de masa corporal es 22. **El examen de elección para descartar causa orgánica en este caso es:**

A Tirotropina

B VDRL

C Hemograma

D Creatinina y enzimas hepáticas

E Glicemia de ayuno

Respuesta A. Tiene una depresión, y la causa orgánica que más la imita es la disfunción tiroidea. La TSH (tirotropina) es la prueba inicial de elección ante cualquier sospecha tiroidea; el hemograma y la glicemia también se piden, pero la más importante es la TSH.

▶ VER CLASE 5.01.4.002 **Exámenes de orina para el control de drogas de abuso** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.16 · Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: agitación o psicosis de inicio reciente (primer episodio psicótico), compromiso de conciencia sin causa clara, dolor torácico en joven, intoxicación sospechada y seguimiento de programas de tratamiento (con consentimiento).
- El tamizaje es por inmunoensayo (rápido, cualitativo); un positivo con implicancias médico-legales requiere confirmación por cromatografía con espectrometría de masas.
- Ventanas aproximadas: cocaína (benzoilecgonina) 2–4 días; anfetaminas 2–3 días; opioides 1–3 días; cannabis 2–3 días en uso ocasional y hasta 30 días en consumo crónico; benzodiacepinas días a semanas según el fármaco.
- Falsos positivos: anfetaminas con descongestionantes (pseudoefedrina), bupropión o trazodona; opioides con quinolonas o semillas de amapola; falsos negativos por orina diluida o adulterada y por sustancias no incluidas en el panel (fentanilo, drogas sintéticas).
- Un resultado positivo indica exposición reciente, no intoxicación actual ni dependencia; el diagnóstico es clínico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 25 años, en un programa de tratamiento por consumo de sustancias, refiere estar abstinente de todas las drogas desde hace 3 semanas. Sin embargo, su examen de orina resulta positivo. Previamente era consumidor diario de varias sustancias. **¿Qué sustancia puede mantenerse positiva en orina por varias semanas después del último consumo en un consumidor crónico?**

A Alcohol

B Cocaína

C Cannabis

D Anfetaminas

E Heroína

Respuesta C. Los metabolitos del cannabis (THC-COOH) son liposolubles y se acumulan en el tejido graso, por lo que en consumidores crónicos pueden detectarse en orina hasta 4 semanas o más. La cocaína (benzoilecgonina), las anfetaminas y los opioides suelen detectarse 2 a 4 días, y el alcohol solo horas.

▶ VER CLASE 5.01.4.003 Niveles plasmáticos de estabilizadores del ánimo

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.2 · Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Litemia: rango 0,6–1,0 mEq/L en mantención y 0,8–1,2 mEq/L en manía aguda; muestra 12 horas después de la última dosis y 5 días después de iniciar o cambiar la dosis; antes de iniciar: creatinina, electrolitos, TSH, ECG y test de embarazo.
- Toxicidad por litio: 1,5–2,0 náuseas, diarrea y temblor fino (suspender e hidratar); 2,0–2,5 temblor grosero, ataxia y confusión (hospitalizar, suero fisiológico); >2,5 convulsiones, arritmias y coma (hemodiálisis). Carbón activado y diuréticos no sirven.
- Suben la litemia: AINE, tiazidas, IECA/ARA-II, deshidratación, vómitos, diarrea y dieta sin sal; control periódico de litemia, función renal (diabetes insípida nefrogénica) y TSH (hipotiroidismo).
- Valproato: 50–100 µg/mL; controlar pruebas hepáticas y plaquetas; teratogénico (tubo neural). Carbamazepina: 4–12 µg/mL; controlar hemograma (aplasia) y sodio (hiponatremia); inductor enzimático.
- Interpretar el nivel junto con la clínica: síntomas de toxicidad con nivel 'normal' en adultos mayores también obligan a suspender.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años con trastorno bipolar tipo I, en tratamiento con carbonato de litio 900 mg al día, con litemia previa de 0,8 mEq/L. Hace 10 días su médico le inició hidroclorotiazida por hipertensión. Consulta por temblor grueso de manos, diarrea, vómitos y marcha inestable. Está somnolienta. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Aumentar la dosis de litio porque el temblor indica descompensación

B Suspender el litio y la tiazida, medir litemia, función renal y electrolitos, e hidratar

C Agregar propranolol para el temblor y mantener el esquema

D Cambiar la tiazida por enalapril y control en 1 mes

E Iniciar haloperidol por probable episodio mixto

Respuesta B. Las tiazidas (y también IECA y AINE) reducen la excreción renal de litio y elevan su nivel plasmático. Temblor grueso, síntomas digestivos, ataxia y compromiso de conciencia sugieren intoxicación: se suspende el litio, se mide litemia (rango terapéutico 0,6 a 1,2 mEq/L), creatinina y electrolitos, y se hidrata; la hemodiálisis se reserva para casos graves.

▶ VER CLASE 5.01.4.004 Tests WAIS y WISC

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.18 · Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Escalas de Wechsler: WISC para niños de 6 a 16 años y WAIS para adolescentes mayores y adultos (WPPSI en preescolares); las aplica un psicólogo.
- Entregan un coeficiente intelectual total con media 100 y desviación estándar 15, más índices (comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento).
- CI <70 (dos DE bajo la media) junto con déficit adaptativo sustenta el diagnóstico de discapacidad intelectual: leve 50–69, moderada 35–49, grave 20–34, profunda <20; 70–84 es rango limítrofe.
- Un perfil con CI normal y bajo rendimiento selectivo orienta a trastorno específico del aprendizaje; grandes discrepancias entre índices sugieren TDAH, trastornos del lenguaje o daño neurológico.
- El resultado se interpreta con la clínica, la escolaridad y factores culturales y emocionales; no diagnostica por sí solo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 9 años, en cuarto básico, con bajo rendimiento global y dificultad para adquirir aprendizajes. El equipo decide medir formalmente su coeficiente intelectual para descartar discapacidad intelectual. **¿Cuál es el instrumento más adecuado?**

A TEPSI

B Escala de inteligencia de Wechsler para adultos (WAIS)

C Minimental test

D Escala de inteligencia de Wechsler para niños (WISC)

E EEDP

Respuesta D. El WISC mide el coeficiente intelectual entre los 6 y 16 años, con índices de comprensión verbal, razonamiento, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. El WAIS se aplica desde los 16 años. El TEPSI (2 a 5 años) y la EEDP (0 a 2 años) tamizan desarrollo psicomotor, y el Minimental evalúa deterioro cognitivo en adultos.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

4 códigos

▶ VER CLASE 5.01.5.001 **EBBA (Escala breve de Beber Anormal)** NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.15 · Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

QUÉ HAY QUE SABER

- EBBA (Escala Breve de Beber Anormal): cuestionario chileno de 7 preguntas de respuesta sí/no sobre consecuencias del consumo de alcohol (problemas con la pareja, la familia o el trabajo, lagunas de memoria, deseo de disminuir, críticas por su forma de beber, beber en la mañana).
- Es un instrumento de tamizaje rápido para APS: se aplica en el EMPA, en consultas de morbilidad y en pacientes con daño compatible (HTA, gastritis, hepatopatía, accidentes, depresión).
- Interpretación: 2 o más respuestas afirmativas sugieren beber problema y obligan a profundizar con AUDIT y evaluación clínica; no diagnostica dependencia por sí sola.
- Aplicar en un ambiente privado, sin juicios, y explicar el objetivo; complementar con cantidad y frecuencia de consumo y signos de abstinencia.
- Un tamizaje positivo da paso a la intervención breve/motivacional y, si corresponde, a la derivación a programa de tratamiento.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 47 años acude a su Examen de Medicina Preventiva. Al aplicar la Escala Breve de Beber Anormal (EBBA) responde afirmativamente 4 de las 7 preguntas: ha tenido discusiones con su esposa por el trago, a veces no recuerda lo que hizo mientras bebía, le molesta que critiquen su forma de beber y ha pensado en disminuir. No refiere temblor ni beber al despertar. **¿Cuál es la interpretación y la conducta más adecuada?**

A Resultado normal; repetir en el próximo EMPA

B Confirma dependencia alcohólica; iniciar disulfiram

C Tamizaje positivo de beber problema; profundizar con AUDIT y evaluación clínica e iniciar intervención breve

D Solicitar GGT y tratar solo si está elevada

E Hospitalizar para desintoxicación

Respuesta C. La EBBA es un instrumento de tamizaje: varias respuestas afirmativas indican beber problema, pero no diagnostican dependencia. El paso siguiente es caracterizar el consumo (AUDIT, cantidad, frecuencia, abstinencia) e iniciar intervención breve. La GGT puede apoyar, pero un valor normal no descarta el problema; no hay criterio para fármacos de deshabituación ni hospitalización.

▶ VER CLASE 5.01.5.002 **Examen físico y neurológico: control de neurolépticos de depósito** NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.10 · Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES
Psiquiatría 17.13 · Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Antipsicóticos de depósito: flufenazina decanoato IM cada 2–4 semanas, haloperidol decanoato IM cada 4 semanas o atípicos de acción prolongada (risperidona, paliperidona, aripiprazol); indicados por psiquiatra ante mala adherencia.
- En cada control: examen neurológico dirigido buscando parkinsonismo (temblor de reposo, rigidez en rueda dentada, bradicinesia), acatisia, distonía y discinesia tardía (movimientos orolinguales y coreoatetósicos de dedos).
- Discinesia tardía: no agregar anticolinérgicos (la empeoran); registrar y derivar para reducir o cambiar el antipsicótico (atípico o clozapina). Parkinsonismo: biperideno temporal y avisar al psiquiatra; acatisia: propranolol.
- Alerta de síndrome neuroléptico maligno: fiebre, rigidez en caño de plomo, disautonomía, compromiso de conciencia y CPK elevada: suspender el antipsicótico y derivar de urgencia (UPC, hidratación, bromocriptina o dantroleno).
- Control físico: peso, cintura, PA, FC y glicemia/lípidos periódicos; técnica IM profunda en glúteo o deltoides con rotación de sitios y revisión del sitio de punción.
- Evaluar además adherencia, síntomas psicóticos, riesgo suicida y consumo de sustancias, coordinando con el equipo de salud mental.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un joven de 20 años es llevado a la consulta médica por sus padres debido a que en los últimos 7 meses ha abandonado la universidad, se aísla en su habitación y afirma que una organización criminal lo espía a través de la televisión. En el examen mental se constata afecto aplanado, soliloquios y alucinaciones auditivas de voces que comentan lo que hace. El examen físico y el screening de drogas en orina son normales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y la conducta médico-legal más adecuada? **¿Cuál es el diagnóstico clínico y la conducta médico-legal más adecuada?**

A Trastorno delirante crónico; manejo ambulatorio exclusivo en APS sin derivación

B Primer episodio de esquizofrenia; activar GES 34, iniciar antipsicótico atípico y derivar a confirmación por especialista

C Trastorno esquizoafectivo; indicar sertralina 100 mg y reposo en casa

D Psicosis reactiva breve; esperar resolución espontánea antes de cumplir el mes

E Trastorno de personalidad esquizotípico; indicar psicoterapia individual sin fármacos

Respuesta B. Cumple criterios de esquizofrenia: síntomas positivos (delirio de persecución, voces comentadoras), negativos (aplanamiento, abulia) y disfunción sociolaboral de más de 6 meses, con tóxicos negativos. En Chile es un primer episodio de esquizofrenia cubierto por GES 34: confirmación por psiquiatra en 20 días como máximo y tratamiento integral dentro de 24 horas desde la confirmación. Se notifica, se inicia un atípico (por ejemplo risperidona u olanzapina) y se deriva. La psicosis breve dura menos de un mes.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 52 años con esquizofrenia, estable hace 8 años con flufenazina decanoato intramuscular cada 3 semanas. En su control de inyección en el CESFAM, la enfermera nota que mueve la lengua y los labios en forma repetitiva, como si masticara, y que tamborilea los dedos. El paciente no lo percibe. Sin síntomas psicóticos activos. **¿Cuál es la interpretación y la conducta más adecuada?**

A Discinesia tardía; registrar con un examen neurológico dirigido, no agregar anticolinérgicos y derivar a psiquiatría para evaluar el cambio a un antipsicótico atípico o clozapina

B Distonía aguda; administrar biperideno intramuscular y mantener igual

C Recaída psicótica con estereotipias; aumentar la dosis de flufenazina

D Acatisia; indicar propranolol

E Síndrome neuroléptico maligno; hospitalizar en UCI

Respuesta A. Movimientos coreoatetósicos orolinguales y de dedos tras años de un neuroléptico típico de depósito son discinesia tardía. Por eso cada control de depósito incluye examen neurológico buscando extrapiramidalismo y discinesias. Los anticolinérgicos la empeoran; se deriva para reducir o cambiar el antipsicótico.

▶ VER CLASE 5.01.5.003 Intervención en crisis

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.3 · Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización

QUÉ HAY QUE SABER

- Intervención en crisis (primera ayuda psicológica): intervención breve y focalizada para restablecer el equilibrio tras un evento crítico (catástrofe, duelo súbito, asalto, intento suicida), aplicable por cualquier profesional de salud.
- Pasos: contacto empático y escucha activa sin forzar el relato, asegurar seguridad física y necesidades básicas (abrigo, alojamiento, comida), normalizar la reacción como esperable y entregar psicoeducación.
- En Chile se usa el modelo ABCDE: escucha Activa, reentrenamiento de la ventilación (Breathing), Categorización de necesidades, Derivación a redes y psicoEducación.
- Evaluar riesgo suicida y de daño a terceros, consumo de alcohol y personas vulnerables (niños, adultos mayores); activar redes de apoyo familiares e institucionales.
- No usar debriefing obligatorio ni benzodiacepinas preventivas (no previenen el TEPT y pueden empeorarlo).
- Acordar seguimiento cercano y derivar si los síntomas persisten más allá de semanas o hay riesgo.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 38 años llega al SAPU 2 horas después de que su casa se incendiara por completo. Nadie resultó herido. Está llorando, temblorosa, dice que no sabe dónde dormirá esta noche con sus 2 hijos y repite que no puede pensar. No tiene antecedentes psiquiátricos ni ideas de muerte, está orientada y su examen físico es normal. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Realizar intervención en crisis: escucha activa, contención, asegurar necesidades básicas y activar redes de apoyo, con seguimiento cercano

B Indicar diazepam endovenoso y derivar a psiquiatría

C Pedirle que relate en detalle el incendio para procesar el trauma (debriefing obligatorio)

D Iniciar sertralina para prevenir el trastorno de estrés postraumático

E Hospitalizar en psiquiatría por reacción aguda a estrés

Respuesta A. La intervención en crisis (primera ayuda psicológica) busca restablecer el equilibrio: escuchar sin forzar el relato, contener, cubrir necesidades básicas como seguridad y alojamiento, conectar con redes de apoyo y evaluar riesgo. El debriefing forzado y los fármacos preventivos no han demostrado beneficio y pueden empeorar la evolución.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años presenció hace 3 horas un accidente de tránsito en que murió su compañero de trabajo. Llega al CESFAM acompañado de su esposa: está inquieto, llora a ratos, dice sentirse aturdido y teme no poder dormir. Está orientado, sin consumo de alcohol, sin ideas de muerte ni síntomas psicóticos. **¿Cuál de las siguientes acciones corresponde a una adecuada intervención en crisis?**

A Indicarle que olvide lo ocurrido y retome su trabajo al día siguiente

B Realizar una sesión única obligatoria de relato detallado del accidente

C Iniciar clonazepam por 3 meses para prevenir un trastorno de estrés postraumático

D Derivarlo de urgencia a hospitalización psiquiátrica

E Escucharlo sin presionarlo a relatar detalles, validar su reacción como esperable, reforzar el apoyo de su esposa y acordar un control cercano

Respuesta E. La intervención en crisis es breve y focalizada: contacto empático, escucha sin forzar el relato, normalizar la reacción, evaluar riesgo, cubrir necesidades inmediatas, activar la red de apoyo y asegurar seguimiento. Las benzodiacepinas prolongadas y el debriefing obligatorio no previenen el estrés postraumático y pueden empeorarlo.

▶ VER CLASE 5.01.5.004 Mini mental test, MoCA test

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.14 · Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

QUÉ HAY QUE SABER

- MMSE (Minimental): 30 puntos; evalúa orientación, registro, atención y cálculo, memoria diferida, lenguaje y praxia constructiva; corte habitual <24, ajustado por escolaridad; poco sensible para deterioro cognitivo leve.
- En el EMPAM chileno se usa el Minimental abreviado: <13 puntos es alterado y se complementa con el cuestionario de actividades funcionales de Pfeffer al informante (≥6 indica compromiso funcional).
- MoCA: 30 puntos, corte <26 (sumar 1 punto si la escolaridad es ≤12 años); más sensible para deterioro cognitivo leve y función ejecutiva, pero penaliza la baja escolaridad.
- Aplicación: paciente vigil, sin delirium, con lentes y audífonos, en ambiente tranquilo; el test del reloj es complementario y se altera precozmente en el Alzheimer.
- Un test alterado no diagnostica demencia: se requiere compromiso funcional, evaluación clínica y estudio de causas reversibles (TSH, B12, VDRL, neuroimagen); un test normal con quejas corroboradas obliga a aplicar MoCA o seguir controlando.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 70 años, profesor universitario jubilado, consulta por quejas de memoria de 1 año, corroboradas por su esposa. Es completamente autónomo. Su Minimental (MMSE) es de 29/30. **¿Cuál es el siguiente paso más adecuado para evaluar un posible deterioro cognitivo leve?**

A Solicitar PET cerebral

B Repetir el Minimental en una semana

C Tranquilizarlo, ya que el Minimental es normal

D Solicitar electroencefalograma

E Aplicar el test MoCA

Respuesta E. El Minimental tiene efecto techo y baja sensibilidad para deterioro cognitivo leve, sobre todo en personas de alta escolaridad. El MoCA evalúa mejor funciones ejecutivas y atención, y es más sensible para detectarlo (punto de corte habitual 26, con un punto adicional si la escolaridad es 12 años o menos). Ante quejas corroboradas no basta con un MMSE normal.

16 DERMATOLOGÍA

60 CÓDIGOS

108 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	33
Situaciones clínicas de urgencia	16
Conocimientos generales	3
Exámenes e imagenología	7
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	1

Situaciones clínicas

33 códigos

▶ VER CLASE 6.01.1.001 **Acné**

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.2 · Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína

QUÉ HAY QUE SABER

- Acné vulgar: comedones (abiertos/cerrados) + pápulas, pústulas o nódulos en cara, pecho y espalda; el comedón es la lesión que lo define. Fisiopatología: hiperqueratinización folicular, exceso de sebo (andrógenos) y Cutibacterium acnes.
- Escalonamiento: comedoniano → retinoide tópico (adapaleno 0,1 %, de noche) ± peróxido de benzoilo; pápulo-pustuloso leve-moderado → peróxido de benzoilo + retinoide ± clindamicina tópica.
- Nunca antibiótico tópico en monoterapia (resistencia en semanas). Pápulo-pustuloso moderado-severo o extenso: doxiciclina o minociclina oral 8–12 semanas junto a peróxido de benzoilo (fotosensibilidad, esofagitis; contraindicadas en embarazo y <8 años).
- Isotretinoína oral: acné nódulo-quístico/conglobata, con cicatrices o refractario tras ciclo completo de antibiótico oral. Teratógeno extremo: doble anticoncepción desde 1 mes antes hasta 1 mes después, test de embarazo previo y mensual; control de perfil lipídico y hepático; queilitis es efecto esperado.
- Seguimiento completo por el médico general: evaluar respuesta a 8–12 semanas, escalar si no responde y derivar a dermatología los casos con cicatrices o candidatos a isotretinoína.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 78

Paciente de 17 años consulta por acné. Al examen físico se observan múltiples comedones en cara, pecho y espalda, asociados a pápulas y pústulas abundantes, y presencia de algunos quistes en dichas zonas con cicatrices atróficas. **¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente?**

A Peróxido de benzoilo tópico
B Clindamicina tópica
C Isotretinoína oral
D Doxiciclina oral
E Adapaleno tópico

Respuesta C. Comedones extensos, pápulas y pústulas abundantes, con quistes y cicatrices atróficas: acné nódulo-quístico, inflamatorio severo. El tratamiento de elección es la isotretinoína oral. Las demás opciones son escalones tópicos u orales insuficientes para este grado de severidad y de cicatrización.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Joven de 17 años consulta por lesiones faciales de 6 meses de evolución que le generan angustia social. Al examen físico se aprecian abundantes comedones abiertos y cerrados en frente y mejillas, con escasas pápulas eritematosas no confluentes, sin nódulos, quistes ni cicatrices. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado?**

A Adapaleno tópico en gel, aplicado en la noche
B Doxiciclina oral 100 mg al día por 8 semanas
C Clindamicina tópica en monoterapia
D Isotretinoína oral en dosis bajas
E Corticoide tópico de baja potencia

Respuesta A. Comedones predominantes con escasas pápulas no confluentes, sin nódulos ni cicatrices: acné comedoniano leve. El tratamiento de primera línea es un retinoide tópico, como el adapaleno, aplicado en la noche; puede asociarse peróxido de benzoilo. No corresponden antibióticos orales, isotretinoína ni la clindamicina en monoterapia.

▶ VER CLASE 6.01.1.002 **Alopecías**

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.4 · Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno

QUÉ HAY QUE SABER

- Primer paso: examinar el cuero cabelludo. Orificios foliculares conservados = alopecia no cicatricial (potencialmente reversible); piel lisa y brillante sin orificios = cicatricial (irreversible; lupus discoide, liquen plano pilar) y requiere biopsia precoz.
- Androgenética (la más frecuente): miniaturización por DHT. Hombre: entradas y vértex (Hamilton-Norwood); mujer: raya central ensanchada con línea frontal respetada (Ludwig).
- Areata: placa redonda, lisa, sin eritema ni descamación, con pelos «en signo de exclamación» en el borde; autoinmune, se asocia a tiroiditis y vitíligo. Efluvio telógeno: caída difusa 2–3 meses tras parto, cirugía, fiebre, déficit de fierro o baja de peso brusca; tracción positiva difusa.
- Tratamiento inicial: androgenética minoxidil tópico 2–5 % ± finasteride oral (contraindicado en mujer fértil); areata en placas corticoide intralesional (triamcinolona) o tópico muy potente; efluvio telógeno solo tranquilizar (se resuelve en ~6 meses) y corregir la causa (fierro, TSH).
- Seguimiento: derivar a dermatología las alopecias cicatriciales, areata extensa (total/universal), sin respuesta o con diagnóstico dudoso. Descartar tiña capitis en niños con placa descamativa.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 151

Un paciente de 19 años consulta por caída de cabello en la zona occipital, que inició hace 2 semanas. Al examen físico se aprecia una zona sin cabellos, redondeada y de piel lisa, sin eritema ni descamación. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Lupus eritematoso cutáneo crónico
B Alopecia areata
C Alopecia androgénica
D Tricotilomanía
E Tiña capitis

Respuesta B. Zona alopécica única, de aparición reciente, de piel lisa sin eritema ni descamación, en un joven de 19 años: alopecia areata. El lupus discoide es cicatricial y de curso más lento; la androgenética no aparece así de rápido ni en placa única a esta edad; la tricotilomanía muestra pelos rotos irregulares por arrancamiento; la tiña capitis suele tener descamación.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 32 años consulta 3 meses después de dar a luz, porque nota caída masiva del cabello al peinarse y en la almohada. Al examen no hay placas alopécicas circunscritas; el cuero cabelludo es normal, con orificios foliculares conservados, y la prueba de tracción es positiva de forma difusa en toda la cabeza. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar minoxidil tópico al 5 % de inmediato
B Solicitar biopsia de cuero cabelludo con urgencia
C Tranquilizar a la paciente y explicar que se resolverá en unos meses
D Indicar corticoide intralesional en el vértex
E Iniciar finasteride oral 1 mg al día

Respuesta C. Caída difusa, sin placas circunscritas, con tracción positiva generalizada y 3 meses después del parto: efluvio telógeno agudo puerperal. Es benigno y autolimitado; la conducta es tranquilizar a la paciente. La biopsia es para la alopecia cicatricial, el corticoide intralesional para la areata, y el minoxidil o el finasteride para la androgenética; ninguno corresponde aquí.

▶ VER CLASE 6.01.1.003 Cáncer de piel no melanoma (carcinoma basocelular y espinocelular)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.14 · Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)

QUÉ HAY QUE SABER

- Basocelular (75–80 %): pápula o nódulo perlado, translúcido, con telangiectasias y borde arrollado; puede ulcerarse al centro (úlcera de Rodent, forma nódulo-ulcerativa, 60 %). Variantes superficial (placa eritematodescamativa en tronco) y morfeiforme (placa amarillenta tipo cicatriz, la más agresiva localmente). Metástasis casi nulas (<0,01 %), pero destruye localmente (cartílago, hueso, órbita). Asociado a quemaduras solares intermitentes en la infancia; es el tumor palpebral maligno más frecuente.
- Espinocelular (15–20 %): placa o nódulo indurado, hiperqueratósico, costroso, que sangra o se ulcera; nace sobre queratosis actínica o queilitis actínica; depende de la dosis acumulada de sol (trabajadores al aire libre) y de la inmunosupresión (trasplantados, riesgo ~65 veces mayor).
- Riesgo de metástasis del espinocelular: 2–5 % en piel y hasta 15–20 % en labio inferior y pabellón auricular (invasión perineural y ganglios regionales).
- Manejo inicial: sospechar ante lesión que no cicatriza en 4 semanas o crece, en zona fotoexpuesta; biopsia diagnóstica y derivación. El tratamiento curativo es la extirpación quirúrgica con margen oncológico; cirugía micrográfica de Mohs en cara y zonas críticas.
- Seguimiento: derivar a dermatología/cirugía (cáncer de piel no melanoma); de por vida control de piel por riesgo de nuevos tumores y fotoprotección estricta.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 80

Un hombre de 70 años, consulta por una lesión en la mano derecha, que apareció hace 6 meses y que ha crecido progresivamente. Es dolorosa y se ulcera y sangra con facilidad. Al examen físico se aprecia una lesión escamosa, ulcerada, de 2 cm de diámetro. Como antecedente, trabajó por 20 años, como minero, en la región de Tarapacá. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Carcinoma espinocelular
B Carcinoma basocelular
C Melanoma maligno
D Granuloma piógeno
E Queratosis actínica

Respuesta A. Lesión escamosa, ulcerada, dolorosa y sangrante, con antecedente de décadas de fotoexposición como minero: carcinoma espinocelular clásico. El granuloma piógeno sangra mucho, pero tiene un aspecto rojo y húmedo, no escamoso.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 74 años, jubilado, ex trabajador agrícola, consulta por una lesión en el labio inferior de 4 meses de evolución que no cicatriza. Al examen se observa una placa de 1 cm, de base indurada, cubierta por una costra hiperqueratósica amarillenta adherente, que sangra al desprenderse. No se palpan adenopatías submentonianas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y qué característica obliga a un seguimiento estricto?**

A Carcinoma basocelular; el riesgo de metástasis es prácticamente nulo

B Carcinoma espinocelular; el labio inferior es una localización de alto riesgo metastásico

C Queilitis actínica simple; basta con fotoprotección

D Herpes labial recidivante; tratar con aciclovir tópico

E Chancro sifilítico; solicitar serología para sífilis

Respuesta B. Placa indurada, costrosa y ulcerada que no cicatriza en el labio inferior de un paciente con antecedente de exposición solar acumulada: carcinoma espinocelular. El labio inferior es una localización de alto riesgo de metástasis ganglionar (hasta 15-20%), a diferencia del carcinoma basocelular, que casi nunca metastiza.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 88

Una paciente de 84 años consulta por aparición de una lesión en la zona supraciliar izquierda, hace 12 meses, pruriginosa, que en ocasiones se ulcera y sangra. Al examen físico se observa lo siguiente: FOTO (Mujer adulta mayor con lesión ulcerada en la zona supraciliar, borde eritematoso, de 1 cm de diámetro aprox.). El diagnóstico más probable es:

A Carcinoma basocelular

B Queratosis actínica

C Queratosis seborreica

D Granuloma piógeno

E Melanoma acrómico

Respuesta A. Diagnóstico: Carcinoma basocelular (opción A). Si bien la imagen no era un cáncer basocelular clásico, esa era la única respuesta aceptable. La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la cara que se caracteriza por no tener comedones, lo que la diferencia del acné.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 84

Un paciente de 83 años, calvo, con antecedente de múltiples queratosis actínicas en la cabeza, presenta una lesión en el cuero cabelludo, que notó hace 3 meses y que ha ido creciendo hasta alcanzar un diámetro de 2 x 3 cm. Se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A Melanoma

B Impétigo

C Dermatitis de contacto

D Quemadura solar

E Carcinoma espinocelular

Respuesta E. Tanto por las queratosis actínicas (premalignas, que evolucionan a cáncer espinocelular) como por la imagen, tiene un cáncer espinocelular.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 111

IMAGEN: Calvo con antecedente de queratosis actínica, muestran lesión en cabeza: a. Carcinoma espinocelular

A Derrame pleural

B Neumotórax

C Neumonía

D Atelectasia

E Masa pulmonar

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Derrame pleural). La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la cara que se caracteriza por no tener comedones, lo que la diferencia del acné.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 63

Una paciente de 58 consulta por aparición de una lesión pruriginosa, de 3 meses de evolución en el párpado inferior derecho, que ha aumentado de volumen. Al examen físico, se observa lo siguiente: Foto 5 (https://martindevoto.com/XXXXXXXXXX-foto/). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Orzuelo

B Verruga vulgar

C Herpes simplex

D Carcinoma basocelular

E Chalazión

Respuesta D. Diagnóstico: Carcinoma basocelular (opción D). Es un cáncer basocelular clásico. La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la cara que se caracteriza por no tener comedones, lo que la diferencia del acné.

▶ VER CLASE 6.01.1.004 Dermatitis atópica

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.6 · Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación

QUÉ HAY QUE SABER

- Dermatitis atópica: eccema pruriginoso crónico recidivante (el prurito intenso es criterio cardinal, Hanifin-Rajka) con xerosis, por defecto de barrera (filagrina) y respuesta Th2/IgE; marcha atópica (asma, rinitis, alergia alimentaria).
- Topografía por edad: lactante <2 años mejillas, cuero cabelludo y superficies extensoras, eccema exudativo, respeta el área del pañal; 2–12 años pliegues antecubitales y poplíteos; adulto pliegues, cuello, manos y liquenificación.
- Tratamiento completo: emolientes diarios (técnica de mojar y sellar tras baño corto tibio), jabón syndet, ropa de algodón. Brote: corticoide tópico según zona (cara/pliegues baja potencia, hidrocortisona 1 % o tacrolimus; tronco y extremidades mediana-alta potencia como betametasona 7–14 días); antihistamínico sedante nocturno si interfiere con el sueño.
- Complicaciones: impetiginización por S. aureus (costras melicéricas: mupirocina tópica o cefadroxilo oral); eccema herpético de Kaposi (vesículas umbilicadas + fiebre) es urgencia: hospitalizar y aciclovir EV.
- Seguimiento: derivar a dermatología los casos moderados-severos refractarios (fototerapia, inmunosupresores, biológicos), con complicaciones o diagnóstico dudoso.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 7 meses es traído por su madre por presentar lesiones rojas muy pruriginosas en ambas mejillas que le impiden dormir. Al examen físico se aprecia eritema brillante exudativo con pequeñas vesículas y costras en ambas mejillas, respetando el área perioral, y lesiones similares en las caras extensoras de brazos y piernas. Al desvestirlo, la piel de toda la región glútea e inguinal cubierta por el pañal está completamente sana. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar fórmula con proteína hidrolizada de forma inmediata

B Baños cortos con syndet, emolientes e hidrocortisona tópica al 1 % en las mejillas

C Iniciar aciclovir endovenoso de urgencia

D Indicar betametasona tópica de alta potencia en toda la cara

E Solicitar biopsia cutánea para confirmar el diagnóstico

Respuesta B. Eccema exudativo pruriginoso en mejillas, respetando estrictamente el pañal, en un lactante: dermatitis atópica del lactante. La conducta es cuidados generales de la piel más un corticoide de baja potencia en la cara. La betametasona de alta potencia en la cara produce atrofia; el aciclovir es para el eccema herpético, que aquí no hay signos de; y la biopsia no es necesaria en un cuadro tan característico.

▶ VER CLASE 6.01.1.005 Dermatitis del pañal

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.7 · Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

QUÉ HAY QUE SABER

- Dermatitis irritativa del pañal: eritema, descamación o erosiones en convexidades (glúteos, genitales, zona perineal) que respeta los pliegues; causada por humedad, orina/deposiciones y fricción.
- Sobreinfección por Candida: eritema rojo intenso y brillante que compromete los pliegues inguinales, con pápulas, pústulas y lesiones satélites; sospechar si persiste >3 días pese a tratamiento.
- Tratamiento completo: cambios frecuentes de pañal, aseo suave con agua o aceite (sin toallitas con alcohol), dejar zona al aire, pasta de óxido de zinc o vaselina como barrera en cada cambio.
- Si hay Candida: antifúngico tópico (clotrimazol o nistatina) 2–3 veces al día hasta 1–2 semanas. Evitar corticoides potentes en la zona del pañal (absorción y atrofia); hidrocortisona 1 % solo en ciclos cortos si hay inflamación marcada.
- Seguimiento completo por médico general; reconsiderar diagnóstico (dermatitis seborreica, psoriasis del pañal, acrodermatitis enteropática, histiocitosis) si no responde.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 7 meses con eritema en la zona del pañal de 10 días que no mejoró con pasta de óxido de zinc. Al examen hay eritema rojo intenso, brillante, que compromete los pliegues inguinales, con pápulas y pústulas satélites en la periferia. **¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento más adecuado?**

A Dermatitis irritativa del pañal; corticoide de alta potencia

B Psoriasis del pañal; calcipotriol

C Dermatitis del pañal sobreinfectada por Candida; antifúngico tópico (clotrimazol o nistatina) y medidas de cuidado del pañal

D Impétigo; cefadroxilo oral

E Dermatitis seborreica; ketoconazol oral

Respuesta C. La dermatitis irritativa del pañal respeta los pliegues. El compromiso de pliegues con eritema intenso y lesiones satélites indica sobreinfección por Candida, frecuente tras más de 3 días de evolución. Se trata con antifúngico tópico, cambios frecuentes, aseo suave y pasta barrera. Los corticoides potentes están contraindicados en esta zona.

▶ VER CLASE 6.01.1.006 Dermatitis seborreica infantil y del adulto

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.7 · Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

QUÉ HAY QUE SABER

- Dermatitis seborreica: dermatosis eritematoescamosa crónica por respuesta anormal a Malassezia; escamas grasosas, untuosas y amarillentas en zonas seborreicas: cuero cabelludo (caspa), surcos nasogenianos, cejas, entrecejo, retroauricular y región esternal. Prurito leve.
- Lactante: costra láctea y eritema en cuero cabelludo y zona interciliar; benigna y autolimitada, en un niño de buen aspecto y con buena ganancia de peso.
- Tratamiento del adulto: champú de ketoconazol 2 % o sulfuro de selenio 2–3 veces por semana, ketoconazol crema en cara, y corticoide tópico de baja potencia en ciclos cortos para el brote inflamatorio.
- Tratamiento del lactante: no requiere antimicóticos; vaselina o aceite para ablandar y retirar las escamas, champú suave.
- Bandera roja: forma severa, extensa y refractaria en adulto joven obliga a pedir VIH; también más grave en Parkinson. Seguimiento completo: es crónica y recidivante, se controlan las recaídas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 40 años consulta por descamación y enrojecimiento facial de 1 año, que empeora en invierno y en períodos de estrés. Al examen hay placas eritematosas mal delimitadas cubiertas por escamas amarillentas de aspecto oleoso en los surcos nasogenianos, las cejas y la región retroauricular, además de caspa en el cuero cabelludo. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado?**

A Terbinafina oral por 6 semanas

B Isotretinoína oral

C Ketoconazol al 2% tópico en crema y champú

D Prednisona oral en dosis bajas por 1 mes

E Peróxido de benzoílo en gel

Respuesta C. Escamas amarillentas oleosas en zonas seborreicas, como surcos nasogenianos, cejas, retroauricular y cuero cabelludo, con brotes por frío y estrés, son una dermatitis seborreica del adulto. La base del tratamiento son los antifúngicos tópicos contra Malassezia, como ketoconazol en crema y champú; los corticoides tópicos de baja potencia solo en ciclos cortos.

▶ VER CLASE 6.01.1.007 Dermitis de contacto

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.7 · Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

QUÉ HAY QUE SABER

- Irritativa (80 %): daño tóxico directo sin sensibilización previa (detergentes, agua y jabón, solventes: «eccema de dueñas de casa»); ardor y tirantez, lesión confinada al área de contacto con bordes netos, piel fisurada. Parche negativo.
- Alérgica (20 %): hipersensibilidad retardada tipo IV; requiere sensibilización previa. Prurito intenso, eccema con vesículas que sobrepasan el área de contacto. Níquel (bisutería, hebillas, botones, piercings) es el alérgeno más frecuente; cromo en cemento húmedo.
- Confirmación de la alérgica: pruebas epicutáneas (patch test) con lecturas a las 48 y 96 horas.
- Tratamiento completo: identificar y evitar el agente, guantes con forro de algodón y cremas barrera (irritativa); corticoide tópico de mediana-alta potencia (cara y pliegues baja potencia) en brote agudo, compresas frías en lesiones exudativas, antihistamínico para el prurito.
- Seguimiento completo: controlar recidiva y educación laboral; derivar si es crónica, ocupacional o sin causa identificada para patch test.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 144

Una adolescente de 15 años presenta lesiones en ambas orejas, que se extienden hasta el cuello. Tiene antecedente de hacerse piercings hace una semana. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Celulitis

B Erisipela

C Dermatitis de contacto alérgica

D Dermatitis de contacto irritativa

E Piodermitis superficial

Respuesta C. Lesión que aparece tras un piercing y se extiende más allá de la zona del aro, hacia el cuello, orienta a una dermatitis de contacto alérgica al níquel del piercing, que sobrepasa el área de contacto. La celulitis no se explica sin tejido celular subcutáneo en la oreja.

▶ VER CLASE 6.01.1.008 Enfermedades de transmisión sexual

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.4 · Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas

QUÉ HAY QUE SABER

- Sífilis (Treponema pallidum): primaria = chancro único, indurado, indoloro, de fondo limpio con adenopatía regional indolora (cura sola en 3–6 semanas); secundaria = roséola maculopapular que compromete palmas y plantas, condilomas planos perianales y poliadenopatías; latente (precoz <1 año, tardía >1 año o desconocida); terciaria = gomas, aortitis, neurosífilis.

- Serología: VDRL/RPR (no treponémica, cuantitativa) mide actividad y respuesta (curación = caída de 4 veces a los 6–12 meses); MHA-TP/FTA-ABS (treponémicas) confirman y quedan positivas de por vida. VDRL bajo con treponémica negativa = falso positivo biológico (LES, embarazo): no tratar; si hay chancro y serología negativa, repetir en ~3 semanas.
- Tratamiento de sífilis: penicilina benzatina 2.400.000 UI IM dosis única si es precoz; 1 dosis semanal por 3 semanas si es tardía o de duración desconocida. Reacción de Jarisch-Herxheimer benigna (paracetamol). Embarazada alérgica: desensibilizar y tratar con penicilina (doxiciclina contraindicada). Estudiar VIH y tratar contactos de los últimos 90 días.
- Uretritis/cervicitis: doble cobertura siempre, ceftriaxona 500 mg IM dosis única (gonococo) más doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 7 días o azitromicina 1 g (clamidia). Herpes genital: aciclovir 400 mg cada 8 horas por 7–10 días. Chancroide: azitromicina 1 g o ceftriaxona 250 mg IM. Condilomas acuminados: podofilotoxina 0,5 %, imiquimod 5 % o crioterapia.
- Seguimiento completo: control serológico con VDRL cuantitativo, consejería, estudio de otras ITS (VIH, hepatitis B) y notificación obligatoria; contactos sexuales tratados.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 28 años consulta por lesiones en palmas y plantas de 2 semanas, no pruriginosas. Al examen se observan máculas y pápulas eritemato-cobrizas descamativas en palmas y plantas, placas blanquecinas en la mucosa oral y adenopatías generalizadas. Refiere una úlcera genital indolora que desapareció sola hace 2 meses. **¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento de elección?**

A Eritema multiforme; antihistamínicos

B Pitiriasis rosada; observación

C Psoriasis palmoplantar; corticoide tópico

D Sífilis secundaria; penicilina benzatina 2.400.000 UI intramuscular dosis única

E Sífilis terciaria; penicilina sódica endovenosa por 14 días

Respuesta D. Exantema de palmas y plantas cobrizo, lesiones mucosas y adenopatías tras un chancro indoloro autolimitado es sífilis secundaria. Se confirma con VDRL o RPR y prueba treponémica (MHA-TP), y se trata con penicilina benzatina 2,4 millones UI IM dosis única. Debe estudiarse VIH y notificar y tratar contactos.

▶ VER CLASE 6.01.1.009 Eritema nodoso / Eritema indurado de Bazin

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.1 · Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel

QUÉ HAY QUE SABER

- Eritema nodoso: paniculitis septal reactiva; nódulos dolorosos, calientes y eritemato-violáceos de 2–5 cm en la cara anterior de ambas piernas, a veces con fiebre y artralgias; no se ulceran y curan sin cicatriz (cambian de color como un hematoma). Más frecuente en mujeres jóvenes.
- Causas: infección estreptocócica (faringitis), fármacos (anticonceptivos orales, sulfas), sarcoidosis, tuberculosis, enfermedad inflamatoria intestinal, embarazo y otras; en muchos casos es idiopático.
- Eritema indurado de Bazin: paniculitis lobulillar en pantorrillas de mujeres jóvenes, crónica y recurrente, que tiende a ulcerarse; asociado a tuberculosis (buscar PPD/IGRA). Diferenciar de trombosis venosa superficial, celulitis y vasculitis.
- Sospecha y estudio inicial: ASO o cultivo faríngeo, radiografía de tórax, PPD, hemograma/VHS y embarazo; biopsia profunda si es atípico. Tratamiento inicial: reposo con piernas elevadas, AINE, tratar la causa y suspender fármacos.
- Seguimiento: derivar a dermatología o medicina interna para estudio etiológico y manejo de Bazin, recurrencias o falta de causa; el eritema nodoso habitualmente se resuelve en 3–6 semanas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 25 años consulta por nódulos dolorosos, eritemato-violáceos, calientes, de 2 a 4 cm, en la cara anterior de ambas piernas, de 1 semana. No se ulceran. Refiere odinofagia hace 3 semanas. Usa anticonceptivos orales. **¿Cuál es el diagnóstico y el estudio inicial más adecuado?**

A Eritema indurado de Bazin; biopsia y PPD

B Trombosis venosa superficial; ecografía Doppler

C Vasculitis leucocitoclástica; biopsia urgente

D Celulitis bilateral; antibióticos endovenosos

E Eritema nodoso; estudio etiológico con ASO o cultivo faríngeo, radiografía de tórax y PPD

Respuesta E. El eritema nodoso es una paniculitis septal reactiva: nódulos dolorosos en cara anterior de piernas que no se ulceran y curan sin cicatriz. Causas: estreptococo, fármacos (anticonceptivos), sarcoidosis, TBC, EII. Se busca la causa (ASO, radiografía de tórax, PPD). El eritema indurado de Bazin es lobulillar, en pantorrillas y tiende a ulcerarse.

▶ VER CLASE 6.01.1.010 Eritema polimorfo menor

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.12 · Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple

QUÉ HAY QUE SABER

- Eritema polimorfo (multiforme) menor: lesiones en diana típicas de 3 anillos (centro oscuro o ampolla, anillo pálido edematoso, halo rojo) de distribución acral y simétrica (manos, antebrazos, codos, rodillas). Mucosa ausente o una sola, sin fiebre, Nikolsky negativo.
- Causa: infecciosa en >90 %: virus herpes simple (>70 %, herpes labial 1–2 semanas antes) y Mycoplasma pneumoniae (niños); los fármacos son poco frecuentes. Se diferencia de SSJ por dianas de 3 anillos, distribución acral y ausencia de desprendimiento.

- Tratamiento inicial: autolimitado (2–4 semanas); sintomático con antihistamínico oral y corticoide tópico; enjuagues antisépticos o lidocaína viscosa si hay dolor oral. Aciclovir oral si el herpes está activo.
- Recurrente (3–5 brotes al año por VHS): aciclovir profiláctico continuo 400 mg cada 12 horas por 6 meses. Tratar Mycoplasma con macrólido si corresponde.
- Seguimiento completo por médico general; derivar formas major (≥2 mucosas con fiebre) o duda con SSJ.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 26 años consulta por lesiones cutáneas de 2 días de evolución en el dorso de ambas manos y los codos, redondeadas, de 1 a 2 cm, con un centro violáceo, un anillo pálido y un halo rojo bien delimitado. Refiere un episodio de herpes labial hace 9 días, ya en fase de costra. No tiene fiebre, y la mucosa oral está indemne. El signo de Nikolsky es negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Hospitalizar de inmediato por sospecha de Stevens-Johnson
B Manejo ambulatorio con antihistamínico oral y corticoide tópico
C Biopsia cutánea urgente con inmunofluorescencia directa
D Prednisona oral en dosis altas por 2 a 3 meses
E Traslado a Centro de Quemados por riesgo de desprendimiento

Respuesta B. Dianas de 3 anillos, distribución acral, antecedente de herpes labial 9 días antes, sin fiebre, sin mucosas comprometidas y Nikolsky negativo: eritema multiforme minor. El manejo es ambulatorio y sintomático; no hay indicación de hospitalización, biopsia urgente ni corticoides sistémicos.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un adulto joven de 24 años consulta por lesiones redondeadas eritematosas en el dorso de ambas manos y antebrazos, con un centro purpúrico violáceo rodeado por un anillo pálido edematoso y un halo eritematoso externo. Refiere un episodio de herpes labial hace una semana. No se palpan adenopatías y el signo de Nikolsky es negativo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el agente causal más frecuentemente asociado?**

A Síndrome de Stevens-Johnson por ingesta de paracetamol
B Eritema multiforme por infección por Virus Herpes Simple
C Urticaria multiforme por virus de Epstein-Barr
D Penfigoide ampollar por exposición a radiación UV
E Lupus eritematoso discoide por fotosensibilidad

Respuesta B. Lesiones en diana de 3 anillos en zonas acrales, con Nikolsky negativo y antecedente de herpes labial 7 a 14 días antes: eritema multiforme por virus herpes simple, la causa de más del 70% de los casos. SSJ tendría Nikolsky positivo y dianas atípicas de 2 anillos.

▶ VER CLASE 6.01.1.011 Fotodermatosis

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.7 · Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

QUÉ HAY QUE SABER

- Fotodermatosis: lesiones en zonas fotoexpuestas (cara, escote, dorso de manos y antebrazos) tras exposición solar; sospechar con tiempo de latencia desde el sol y distribución en áreas expuestas.
- Tipos frecuentes: erupción polimorfa solar (pápulas/placas pruriginosas horas–días después del sol), urticaria solar (habones minutos tras el sol), fototoxia y fotoalergia por fármacos o plantas, fitofotodermatitis (furocumarinas de plantas + UV: lesiones lineales o caprichosas, luego hiperpigmentadas).
- Fármacos fotosensibilizantes frecuentes: tetraciclinas, tiazidas, AINE, amiodarona, quinolonas; considerar lupus cutáneo y porfirias si hay compromiso sistémico o cicatrices.
- Tratamiento inicial: suspender el agente, evitar el sol, fotoprotección FPS ≥50 de amplio espectro, corticoide tópico en lesiones agudas y antihistamínico oral para el prurito.
- Seguimiento completo con fotoprotección permanente; derivar a dermatología si es recurrente, grave o se sospecha lupus/porfiria.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 115

Paciente de 25 años consulta por lesiones en las extremidades inferiores. Refiere que ayer estuvo jugando fútbol al aire libre y que las lesiones empezaron a aparecer después. Hace 1 año le pasó algo similar luego de andar en moto por los cerros. Al examen físico se observan, en ambos muslos y piernas, múltiples lesiones eritemato-violáceas, muchas con disposición lineal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Fitodermatitis
B Enfermedad ampollar
C Urticaria solar
D Lupus discoide
E Vasculitis leucocitoclástica

Respuesta A. Lesiones eritematosas o hiperpigmentadas de disposición lineal o caprichosa en zonas expuestas, tras contacto con plantas al aire libre y exposición solar, son una fitofotodermatitis (furocumarinas más luz UV). Se maneja con evitar el contacto, fotoprotección y corticoide tópico. La urticaria solar da habones fugaces minutos después del sol.

▶ VER CLASE 6.01.1.012 Granuloma piogénico

DX SOSPECHA TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.8 · Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

QUÉ HAY QUE SABER

- Granuloma piógeno (hemangioma capilar lobulillar): pápula o nódulo exofítico rojo brillante, friable, de superficie lisa y húmeda, con collarete, de crecimiento rápido en semanas, que sangra con facilidad; en dedos, cara y mucosa oral (encías en embarazadas).
- Se asocia a traumatismo menor, embarazo (segundo-tercer trimestre) y fármacos (retinoides, anticonceptivos); es benigno, no purulento ni granulomatoso.
- Diferencial importante: melanoma amelanótico, carcinoma espinocelular, sarcoma de Kaposi, verruga: por eso siempre se envía la pieza a histología.
- Tratamiento completo: exéresis con curetaje y electrocoagulación de la base (o exéresis con sutura), con estudio histológico; también nitrato de plata o láser en lesiones pequeñas. Controlar el sangrado con presión.
- Seguimiento completo: la recurrencia es frecuente si queda tejido residual; en embarazadas se puede diferir hasta el posparto si es asintomático.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 62

Paciente de 28 años, embarazada de 28 semanas, consulta por una lesión cutánea en el dedo medio de algunas semanas de evolución, friable, que ha sangrado en varias oportunidades. Al examen se observa una pápula exofítica rojo brillante, de superficie lisa y húmeda, pediculada, con collarete descamativo en la base. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Verruga vulgar
B Granuloma piógeno
C Molusco contagioso
D Melanoma amelanótico
E Carcinoma basocelular

Respuesta B. Una lesión vascular roja, friable, de crecimiento rápido y sangrado fácil, con collarete, en dedos, en una embarazada, es un granuloma piógeno (hemangioma capilar lobulillar). Se trata con exéresis o curetaje con electrocoagulación y estudio histológico, para descartar un melanoma amelanótico. En el embarazo puede regresar después del parto.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 31

Una paciente de 28 años, embarazada de 28 semanas, consulta por aparición de una lesión cutánea en el dedo medio, de algunas semanas de evolución, friable, que ha sangrado en varias oportunidades. Al examen físico, se observa la siguiente fotografía (fuente: sanchezcarpinterodermatologo.blogspot.com): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Verruga vulgar
B Granuloma piógeno
C Molusco contagioso
D Melanoma amelanótico
E Carcinoma basocelular

Respuesta B. Diagnóstico: Granuloma piógeno (opción B).

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 32

Un adolescente de 14 años consulta por una lesión de color rojo, en el tórax, que apareció hace algunas semanas y que ha sangrado varias veces, en relación al roce de la ropa. Se muestra a continuación: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Pioderma gangrenoso
B Hemangioma infantil
C Nevo atípico inflamatorio
D Granuloma telangiectásico
E Melanoma maligno

Respuesta D. Diagnóstico: Granuloma telangiectásico (opción D).

▶ VER CLASE 6.01.1.013 Hemangiomas cutáneos infantiles

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.17 · Tumores Benignos de Piel, Hemangiomas Infantiles y Malformaciones Vasculares

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemangioma infantil: tumor vascular benigno más frecuente de la infancia; aparece en las primeras semanas de vida como mácula pálida o telangiectasias y luego crece (fase proliferativa hasta 6–12 meses) y involuciona lentamente (hasta los 5–10 años).
- Específico: placa o nódulo rojo brillante («fresa»), superficial, profundo (azulado) o mixto; más frecuente en prematuros, niñas y raza blanca; marcador GLUT-1 positivo. Diferenciar de malformaciones vasculares (presentes al nacer, no involucionan).
- Tratamiento inicial: la mayoría solo observación y control fotográfico. Indicación de tratamiento precoz (propranolol oral 1–3 mg/kg/día por especialista): compromiso periocular o de vía aérea, ulceración, localización de la nariz, labios o región perineal, multifocal (≥5 lesiones) o desfigurante.
- Alerta: hemangioma periocular riesgo de ambliopía; segmentarios de cara se asocian a síndrome PHACE; ≥5 hemangiomas cutáneos obligan a buscar compromiso hepático; segmentario lumbosacro a disrafismo.

- Seguimiento: derivar a dermatología pediátrica (o cirugía infantil/oftalmología según localización) en lactantes con riesgo funcional o rápido crecimiento.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 125

Lactante de 6 meses presenta 8 hemangiomas infantiles localizados en el tronco, principalmente en la espalda. **¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?**

A Solicitar ecografía abdominal
B Iniciar propranolol oral
C Iniciar corticoides intralesionales
D Solicitar una resonancia magnética nuclear de cerebro
E Solicitar estudio de neurofibromatosis

Respuesta A. Cinco o más hemangiomas cutáneos se asocian a hemangiomas hepáticos, que pueden causar insuficiencia cardíaca o hipotiroidismo, por lo que se indica ecografía abdominal. El propranolol se indica según localización, tamaño o complicación de las lesiones, no por su número. La resonancia cerebral se piensa en hemangiomas segmentarios faciales (PHACE).

▶ VER CLASE 6.01.1.014 Linfomas cutáneos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.18 · Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

QUÉ HAY QUE SABER

- Linfomas cutáneos: neoplasias de células T (micosis fungoide, 65 %) o B primarias de la piel. Micosis fungoide: curso lento, mácula o placa eritematosa descamativa, bien delimitada, poiquilodermia, en zonas no expuestas («traje de baño»), que se confunde por años con eccema o psoriasis.
- Sospecha: lesiones de «eccema» o psoriasis crónicas, atípicas, que no responden a corticoides tópicos, con prurito persistente; progresan a placas infiltradas, tumores y eritrodermia.
- Síndrome de Sézary: eritrodermia pruriginosa, adenopatías y células de Sézary circulantes (forma leucémica); queratodermia palmoplantar y onicodistrofia.
- Tratamiento inicial: derivar con biopsia cutánea múltiple e inmunohistoquímica; en etapas precoces corticoides tópicos potentes y fototerapia (PUVA/UVB) por especialista, evitando retrasos por diagnóstico erróneo.
- Seguimiento: derivar a dermatología/hematología para estadificación (TNMB), tratamiento sistémico y control periódico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 113

Paciente con prurito intenso, eritema y descamación difusos de la piel incluyendo ambas manos, que se ven eritematosas y descamativas, engrosamiento de las uñas de manos y pies, y aumento de volumen inguinal bilateral por adenopatías. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Linfoma cutáneo (síndrome de Sézary)
B Sarna noruega
C Psoriasis
D Dermatitis crónica
E Dermatitis atópica

Respuesta A. La tríada de eritrodermia pruriginosa, adenopatías y células de Sézary (linfocitos T atípicos) circulantes define el síndrome de Sézary, la forma leucémica del linfoma T cutáneo (relacionado con micosis fungoide). Se acompaña de queratodermia palmoplantar y onicodistrofia. Se confirma con biopsia de piel, frotis y citometría de flujo.

▶ VER CLASE 6.01.1.015 Líquen plano

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.5 · Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Líquen plano: pápulas planas, poligonales, violáceas y muy pruriginosas (las «6 P») en cara flexora de muñecas, tobillos y región lumbar; estrías de Wickham en superficie. Fenómeno de Koebner positivo.
- Mucosa oral: retículo blanquecino en mucosa yugal; puede haber compromiso ungueal (pterigión), genital y cuero cabelludo (alopecia cicatricial).
- Se asocia a hepatitis C (solicitar serología VHC), fármacos (tiazidas, IECA, antimaláricos) y enfermedades autoinmunes. Diferencial con psoriasis (placas con escama plateada) y liquen simple crónico.
- Tratamiento inicial: corticoide tópico de alta potencia (clobetasol) 2 veces al día + antihistamínico oral para el prurito; en lesión oral, corticoide tópico en orabase.
- Seguimiento: derivar a dermatología si es extenso, ungueal, de cuero cabelludo o no responde; el liquen oral erosivo requiere control periódico por riesgo de carcinoma escamoso.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años con pápulas planas, poligonales, violáceas y muy pruriginosas en la cara flexora de muñecas y tobillos, de 2 meses. En su superficie se observan finas estrías blanquecinas. Aparecieron nuevas lesiones sobre una excoriación lineal. En la mucosa yugal tiene un retículo blanquecino. **¿Cuál es el diagnóstico y qué examen de laboratorio conviene solicitar?**

A Liquen plano; serología de virus hepatitis C

B Psoriasis; perfil lipídico

C Pitiriasis rosada; VDRL

D Lupus discoide; ANA

E Prurigo nodular; IgE total

Respuesta A. Pápulas planas, poligonales, púrpuras, pruriginosas con estrías de Wickham, fenómeno de Koebner y lesiones reticuladas en mucosa oral son liquen plano (las 6 P). Se asocia a hepatitis C, por lo que se solicita su serología. Se trata con corticoides tópicos potentes; el liquen plano oral erosivo crónico requiere seguimiento por riesgo de carcinoma.

▶ VER CLASE 6.01.1.016 Lupus eritematoso cutáneo crónico (lupus discoide)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.10 · Lupus Cutáneo (Subagudo y Crónico Discoide) y Lupus Inducido por Drogas

QUÉ HAY QUE SABER

- Lupus eritematoso cutáneo crónico (discoide): placas eritematosas bien delimitadas con escama adherente y tapones córneos foliculares, borde activo con telangiectasias y atrofia central con cicatriz y despigmentación; en cara (mejillas, nariz), orejas y cuero cabelludo.
- En cuero cabelludo causa alopecia cicatricial irreversible (sin orificios foliculares). Fotosensible; ANA habitualmente negativos o en título bajo; <10 % evoluciona a lupus sistémico. Diferencial: lupus subagudo (lesiones anulares policíclicas sin cicatriz; anti-Ro), rosácea, psoriasis, liquen plano, sarcoidosis.
- Sospecha y confirmación: biopsia cutánea con inmunofluorescencia (banda lúpica) y ANA/anti-ENA para descartar compromiso sistémico.
- Tratamiento inicial: fotoprotección estricta (FPS ≥50), evitar tabaco, corticoide tópico potente o tacrolimus; hidroxicloroquina oral (≤5 mg/kg/día) en lesiones extensas o de cuero cabelludo (control oftalmológico).
- Seguimiento: derivar a dermatología/reumatología; el tratamiento precoz evita cicatrices y alopecia definitiva.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 14

Mujer de 35 años con placas eritematosas en cuero cabelludo con alopecia cicatricial, fotosensibilidad y presencia de tapones foliculares. Presenta lesiones similares en las mejillas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Tinea capitis

B Alopecia androgénica

C Tricotilomanía

D Lupus eritematoso discoide

E Alopecia areata

Respuesta D. Placas eritematosas con escamas adherentes, tapones foliculares y alopecia cicatricial en zonas fotoexpuestas definen el lupus discoide, la forma cutánea crónica. Solo una minoría evoluciona a lupus sistémico. Se trata con fotoprotección, corticoides tópicos y antimaláricos. La alopecia areata no deja cicatriz.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 2

Mujer 30 años con aparición de Placa eritematodescamativa de 2 meses de evolución en pómulo derecho de 3 cm de diámetro y otra similar en cuero cabelludo (zona parietal izquierda) con alopecia central.

A Lupus cutáneo crónico

B Dermatitis seborreica

C Psoriasis

D Liquen plano

E Rosácea

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Lupus cutáneo crónico).

▶ VER CLASE 6.01.1.017 Melanoma maligno

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.13 · Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en lesión pigmentada con ABCDE (Asimetría, Bordes irregulares, Color heterogéneo, Diámetro >6 mm, Evolución); la evolución (cambio, lesión nueva, «patito feo») es el criterio más sensible. Riesgo: fototipo claro, quemaduras solares en la infancia, >50–100 nevos, nevos displásicos, antecedente familiar (CDKN2A).
- Subtipos: extensión superficial (~70 %), nodular (15 %, el más agresivo, nódulo azul-negro), léntigo maligno melanoma (cara de ancianos), lentiginoso acral (palmas, plantas y uñas; el más frecuente en población mestiza chilena y no depende del sol).

- Manejo inicial: la dermatoscopía apoya pero no reemplaza a la biopsia; biopsia excisional completa con margen de 1–2 mm y tejido subcutáneo para medir el Breslow real. Shave y punch superficial están contraindicados (subestiman el espesor).
- El Breslow define el pronóstico y el tratamiento: margen definitivo in situ 0,5 cm, hasta 1 mm 1 cm, 1–2 mm 1–2 cm, >2 mm 2 cm; ganglio centinela si >0,8 mm o con ulceración. Enfermedad avanzada: inmunoterapia anti-PD-1 e inhibidores BRAF/MEK si hay mutación.
- Seguimiento: derivar a dermatología/oncología de forma preferente (garantía de oportunidad) ante sospecha; el médico general no hace la ampliación.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 46 años consulta por un nevo en la espalda que ha cambiado de color y aumentado de tamaño en los últimos 4 meses. Al examen se observa una lesión macular asimétrica de 8 mm con bordes irregulares y tres colores distintos (café claro, negro y grisáceo). **¿Cuál es la conducta diagnóstica de elección?**

A Cauterización con nitrógeno líquido (crioterapia) en la consulta

B Biopsia excisional completa con 1 a 2 mm de margen lateral y celular subcutáneo

C Biopsia por afeitado (shave) superficial para no dejar cicatriz antiestética

D Biopsia por sacabocados (punch) de 2 mm tomada del centro más pigmentado de la lesión

E Control fotográfico digital seriado cada 3 meses

Respuesta B. Ante una lesión con sospecha clínica de melanoma maligno, el estándar de oro diagnóstico es la biopsia excisional completa con márgenes estrechos de 1 a 2 mm y en toda la profundidad del tejido celular subcutáneo, lo que permite medir el espesor de Breslow sin desestructurar la lesión.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 50 años, sin metástasis demostradas, recibe el informe de la biopsia excisional de una lesión pigmentada del dorso que confirma un melanoma de extensión superficial. **¿Cuál es el factor pronóstico más importante en este melanoma localizado?**

A El diámetro de la lesión en la superficie

B El número de colores de la lesión

C El espesor tumoral de Breslow

D La edad de la paciente

E El tiempo de evolución referido por la paciente

Respuesta C. En el melanoma localizado, el factor pronóstico más importante es el espesor de Breslow, medido en milímetros desde la capa granular hasta la célula tumoral más profunda. Define el estadio, los márgenes de ampliación y la indicación de biopsia de ganglio centinela. La ulceración es el segundo factor relevante.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 178

Una paciente de 26 años nota aparición de una lesión en el tercio medio de la pierna derecha, desde hace 6 meses, con crecimiento progresivo. Al examen físico se observa lo siguiente: Fuente: www.alamy.com El diagnóstico más probable es:

A Nevo

B Melanoma

C Léntigo

D Queratosis seborreica

E Queratosis actínica

Respuesta B. Es un melanoma clásico, tanto por la edad, como por el crecimiento. La imagen sí tiene un aspecto de queratosis seborreica, aunque el halo hiperpigmentado y la lesión satélite son más de melanoma.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 115

Paciente de 90 años con 3 lesiones pigmentadas de crecimiento progresivo en la pierna. La mayor se muestra en imagen. ¿Diagnóstico más probable?

A Queratosis seborreica pigmentada

B Melanoma con satelitosis

C Carcinoma basocelular pigmentado

D Nevo melanocítico displásico

E Dermatofibroma pigmentado

Respuesta B. Diagnóstico: Melanoma con satelitosis (opción B). Melanoma con satelitosis. El melanoma maligno es el tumor maligno de piel más mortal aunque no el más frecuente.

▶ VER CLASE 6.01.1.018 Micosis superficiales

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.16 · Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Dermatofitosis (tiñas): hongos filamentosos que digieren queratina. Tiña del cuerpo: placa anular con borde activo solevantado, descamativo o con vesículas y centro que aclara. Tiña inguinal: placa bilateral en pliegues que respeta el escroto (si lo toma con lesiones satélites es candidiasis). Tiña del pie: maceración interdigital (cuarto espacio) o patrón en mocasín.
- Pitiriasis versicolor (Malassezia): máculas hipo o hiperpigmentadas en tronco y cuello con descamación fina al raspar (signo de la uñada); KOH muestra «albóndigas con espaguetis».

- Confirmación: examen micológico directo (KOH) y cultivo de escamas del borde activo, útil sobre todo en uñas y cuero cabelludo; no usar corticoide tópico (empeora y enmascara la tiña, «tiña incógnita»).
- Tratamiento completo: lesiones cutáneas localizadas con antifúngico tópico (terbinafina o clotrimazol 2–4 semanas); pitiriasis versicolor con ketoconazol 2 % champú/crema o terbinafina tópica. Tiña de la cabeza (niños, pelos «en sacapuntas», querion) siempre oral: griseofulvina 20–25 mg/kg/día por 6–8 semanas con comida grasa o terbinafina. Onicomicosis confirmada: terbinafina oral (12 semanas en pies).
- Seguimiento completo: control de la respuesta, tratar fuentes (mascotas, calzado) y derivar formas extensas, recurrentes o refractarias.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 44

Un paciente de 40 años consulta por hiperqueratosis y cambio de coloración de las uñas de los ortejos, de algunos meses de evolución. Se realiza estudio micológico, que muestra presencia de Trichophyton rubrum. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Itraconazol
B Griseofulvina
C Fluconazol
D Terbinafina
E Clotrimazol

Respuesta D. La onicomicosis por dermatofitos, como Trichophyton rubrum, se trata de elección con terbinafina oral, por alrededor de 12 semanas en las uñas de los pies, tras confirmar con estudio micológico. El clotrimazol tópico no penetra la lámina ungueal y la griseofulvina es menos eficaz.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 20

Un escolar de 7 años consulta por una zona alopécica de 2 semanas de evolución, que ha ido en creciendo. Al examen físico se aprecia la placa alopécica de 4 cm, con des- camación y pelos entrecortados, tal como se muestra en la siguiente imagen: INSERTAR FOTO ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Tiña capitis
B Tricotilomanía
C Alopecia areata
D Lupus discoide
E Dermatitis solar

Respuesta A. Diagnóstico: Tiña capitis (opción A). Tiña capitis clásica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 85

Una paciente de 50 años, diabética, con antecedente de insuficiencia renal e hígado graso, consulta por lesiones pruriginosas y eritematosas debajo de las mamas, en la región inguinal y debajo del abdomen. El tratamiento más adecuado es:

A Mupirocina tópica
B Cefadroxilo oral
C Griseofulvina oral
D Fluconazol oral
E Ketoconazol tópico

Respuesta E. Tiene un intétrigo candidiásico. Por el antecedente de IRC y hepatopatía, se prefieren los antimicóticos tópicos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 176

Una paciente de 70 años, diabética en tratamiento farmacológico y con obesidad, consulta por lesiones en el tórax, asociadas a prurito. Al examen físico de pliegues mamarios se encuentran lesiones eritematosas asociadas a rezumación con pequeñas pústulas blancas. El diagnóstico más probable es:

A Acrocordones
B Intértrigo candidiásico
C Impétigo buloso
D Tiña corporis
E Psoriasis

Respuesta B. Diagnóstico: Intértrigo candidiásico (opción B). Es un intértrigo: infección por hongos en los pliegues.

▶ VER CLASE 6.01.1.019 **Pediculosis** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.16 · Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Pediculosis capitis (Pediculus humanus capitis): prurito del cuero cabelludo, sobre todo en la nuca y detrás de las orejas, en escolares; se contagia por contacto directo, peinetas y gorros.
- Diagnóstico: visualizar piojos vivos o liendres firmemente adheridas al tallo del pelo a menos de 1–3 cm del cuero cabelludo (indican infestación activa aunque no se vean piojos adultos); excoriaciones y adenopatías occipitales.
- Tratamiento: permetrina al 1 % en loción o champú (no 5 %, que es para sarna) en el cuero cabelludo, repetida a los 7–10 días porque no es completamente ovicida; remoción mecánica de liendres con peineta fina.

- Alternativas en resistencia: dimeticona o ivermectina oral (casos resistentes). Tratar a los convivientes afectados, lavar ropa de cama y peinetas con agua caliente (>60 °C) o aislar en bolsa cerrada.
- Seguimiento completo por médico general: reevaluar a los 7–10 días; si hay impétigo secundario tratar con antibiótico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 32 años, madre de dos escolares con pediculosis, consulta por prurito del cuero cabelludo de 2 semanas. Al examen se observan piojos vivos y liendres firmemente adheridas al tallo del pelo, cerca de la raíz, en la región occipital y retroauricular. No está embarazada. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Ivermectina oral como primera línea y rapado del cabello

B Corticoide tópico y antihistamínico oral

C Champú de ketoconazol por 4 semanas

D Permetrina al 1% en loción aplicada en el cuero cabelludo, repetida a los 7 a 10 días, con retiro mecánico de liendres y tratamiento de los convivientes afectados

E Lavado diario de cabello con agua y vinagre como única medida

Respuesta D. La pediculosis capitis se trata con pediculicida tópico, de elección permetrina al 1%, repitiendo a los 7 a 10 días porque no es completamente ovicida. Se agrega retiro de liendres con peineta fina, tratamiento simultáneo de los convivientes afectados y lavado de ropa de cama y peinetas.

▶ VER CLASE 6.01.1.020 Pénfigo

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.11 · Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)

QUÉ HAY QUE SABER

- Pénfigo vulgar: autoanticuerpos IgG anti-desmogleína 3 (mucosas) y 1 (piel) → acantolisis, ampolla intraepidérmica suprabasal; adultos de 40–60 años. Es potencialmente mortal.
- Sospecha: erosiones/úlceras orales dolorosas persistentes (primer síntoma en 70–90 %), luego ampollas flácidas sobre piel sana que se rompen y dejan erosiones sangrantes; Nikolsky positivo y Asboe-Hansen positivo.
- Diagnóstico por biopsia: histología con ampolla suprabasal («hilera de lápidas sepulcrales») e inmunofluorescencia directa con depósito intercelular de IgG y C3 en «red de pescar». Toma de muestra: ampolla reciente más piel perilesional.
- Tratamiento inicial: derivar con prednisona 1–1,5 mg/kg/día (con protección gástrica y de hueso); rituximab de primera línea según guías actuales; azatioprina o micofenolato como ahorradores de corticoides. Antes de los corticoides la mortalidad era >70 % (sepsis, deshidratación).
- Seguimiento: derivar a dermatología (hospitalizar si es extenso); control de efectos adversos de corticoides.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 52 años consulta por erosiones dolorosas en la mucosa yugal y encías de 2 meses de evolución, sin respuesta a antimicóticos. Hace 10 días notó ampollas de pared muy delgada en el tronco, que se rompen con el roce de la ropa dejando zonas denudadas dolorosas. Al frotar suavemente la piel sana cercana a una lesión, la epidermis se desprende con facilidad. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento inicial?**

A Penfigoide ampollar; clobetasol tópico de alta potencia

B Pénfigo vulgar; prednisona oral en dosis altas

C Dermatitis herpetiforme; dapsona y dieta sin gluten

D Necrólisis epidérmica tóxica; traslado a Centro de Quemados

E Eritema multiforme major; aciclovir oral

Respuesta B. Úlceras orales dolorosas como debut, ampollas flácidas de pared delgada y Nikolsky positivo en una mujer de mediana edad: Pénfigo Vulgar. El tratamiento inicial es prednisona oral en dosis altas. El penfigoide es Nikolsky negativo y respeta la mucosa oral; no hay antecedente farmacológico ni fiebre para pensar en NET.

▶ VER CLASE 6.01.1.021 Piodermias superficiales y profundas (no linfáticas)

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.1 · Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Piodermias superficiales: impétigo (costras melicéricas periorificiales en niños; S. aureus y S. pyogenes), foliculitis (pústula centrada en un vello; S. aureus; tras tinas calientes piensa en Pseudomonas, autolimitada). Profundas: forúnculo (nódulo doloroso con necrosis central o «clavo»), ántrax estafilocócico (forúnculos coalescentes en nuca/espalda de diabéticos), erisipela y celulitis.
- Impétigo localizado con pocas lesiones: mupirocina 2 % tópica 5–7 días y aseo; extenso o con síntomas: cefadroxilo o flucloxacilina/cloxacilina oral 7–10 días. Foliculitis leve: aseo con clorhexidina o mupirocina 2 %.
- Forúnculo y absceso: calor local e incisión y drenaje; antibiótico sistémico solo si hay celulitis circundante, signos sistémicos, inmunosupresión o localización de riesgo (cara). Sospecha de SAMR comunitario o recurrencias: cotrimoxazol forte o clindamicina y cultivo.
- Alérgicos a betalactámicos: clindamicina 300 mg cada 8 horas. Buscar y tratar puerta de entrada y factores (diabetes, tinea pedis, portación nasal).
- Seguimiento completo: control a las 48–72 horas; derivar ántrax, infección facial, falla de tratamiento o recurrencias múltiples.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 55

Un paciente de 21 años consulta por aparición de lesiones cutáneas en la zona glútea de 6 días de evolución, consistentes en pápulas y pústulas, que están en estrecha relación con los folículos pilosos. **¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente?**

A Flucloxacilina
B Ceftriaxona
C Doxiciclina
D Amoxicilina
E Azitromicina

Respuesta A. Pápulas y pústulas centradas en folículos: foliculitis por Staphylococcus aureus. Entre las opciones, el único antiestafilocócico de elección es la flucloxacilina (también cloxacilina o cefadroxilo; clindamicina en alérgicos). En la foliculitis leve y localizada basta el aseo con clorhexidina o la mupirocina tópica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 111

Niño de 7 años con 3 lesiones eritematosas con costra melicérica en el abdomen, pruriginosas, sin fiebre. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Mupirocina tópica al 2%
B Amoxicilina oral 7 días
C Cefadroxilo oral 10 días
D Clindamicina oral
E Peróxido de benzoilo tópico

Respuesta A. Costras color miel sobre base eritematosa son un impétigo no ampollar (S. aureus o S. pyogenes). Con pocas lesiones, localizado y sin síntomas sistémicos, se trata con antibiótico tópico (mupirocina o ácido fusídico) por 5 a 7 días y aseo. El tratamiento oral (cefadroxilo, cloxacilina) se reserva para lesiones extensas, ampollares o brotes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 86

Un adolescente consulta por aparición de lesiones en zona nasogeniana, eritematosas, pruginosas, desde hace una semana. Al examen físico se aprecian costras melicéricas en la zona descrita. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A Amoxicilina más ácido clavulánico
B Macrólidos
C Betametasona
D Cefoperazona
E Ciprofloxacino

Respuesta A. Tiene un impétigo. Cloxacilina o cefadroxilo habrían sido de elección, pero la amoxicilina más ácido clavulánico cubren bien al S. Aureus y al S. Pyogenes, que son los agentes etiológicos.

▶ VER CLASE 6.01.1.022 Pitiriasis Rosada de Gilbert

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.16 · Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Pitiriasis rosada de Gilbert: exantema autolimitado de adolescentes y adultos jóvenes, probablemente por VHH-6/7. Comienza con una placa heraldo (ovalada, de 2–5 cm, rosada con collarete descamativo) en el tronco.
- 1–2 semanas después aparecen múltiples placas ovaladas menores con collarete, orientadas según las líneas de tensión de la piel (patrón «en árbol de Navidad» en la espalda); prurito leve o ausente; cara, palmas y plantas respetadas.
- Diferencial: tiña del cuerpo (KOH), sífilis secundaria (si hay lesiones palmoplantares o en mucosas: pedir VDRL), psoriasis en gotas, exantemas por fármacos.
- Tratamiento completo: autolimitada (resuelve en 6–8 semanas) y sin secuelas; sintomático con emolientes, antihistamínico oral y corticoide tópico de baja-mediana potencia si hay prurito.
- Seguimiento completo: tranquilizar, explicar curso benigno y controlar si persiste >3 meses o cambia el cuadro.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 121

Mujer de 18 años presenta una placa eritematosa levemente pruriginosa de 5 cm en la espalda, sin otros síntomas. Una semana después se agregan múltiples lesiones similares, de menor tamaño, en todo el tronco. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Tiña
B Lupus cutáneo subagudo
C Sífilis secundaria
D Pitiriasis versicolor
E Pitiriasis rosada

Respuesta E. Una placa heraldo seguida en 1 a 2 semanas de placas ovaladas más pequeñas con collarete, orientadas según las líneas de tensión del tronco (en árbol de Navidad), es pitiriasis rosada de Gilbert, probablemente viral (VHH 6 y 7). Es autolimitada en 6 a 8 semanas; se trata sintomáticamente. Ante dudas o lesiones palmoplantares, solicitar VDRL.

▶ VER CLASE 6.01.1.023 Prúrigo infantil agudo, picadura de insectos

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.16 · Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Prúrigo infantil agudo (estrófulo): reacción de hipersensibilidad a picaduras de insectos (pulgas, mosquitos, chinches) en niños de 2–7 años, de curso estacional.
- Pápulas eritematosas pruriginosas con vesícula o costra central y excoriaciones, agrupadas («desayuno, almuerzo y cena», en líneas de 3) en zonas descubiertas: piernas, antebrazos, cara.
- Diferencial: escabiosis (prurito nocturno, convivientes, pliegues interdigitales, genitales), varicela (vesículas en distintos estadios), dermatitis atópica, impétigo.
- Tratamiento completo: antihistamínico oral, corticoide tópico de baja-mediana potencia en las lesiones, compresas frías y repelentes; control ambiental del vector (mascotas, colchones, desinsectación).
- Seguimiento completo: evitar rascado, tratar sobreinfección bacteriana (mupirocina o cefadroxilo) y educar en prevención de picaduras.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 4 años con lesiones muy pruriginosas de 1 semana, tras vacaciones en el campo. Al examen hay pápulas eritematosas con vesícula central y excoriaciones agrupadas en zonas descubiertas (piernas y antebrazos), algunas en línea de 3. Nadie más en la casa tiene prurito y no hay lesiones en pliegues interdigitales ni genitales. **¿Cuál es el diagnóstico y manejo más adecuado?**

A Prúrigo agudo infantil por picadura de insectos; antihistamínico oral, corticoide tópico de baja o mediana potencia y control de insectos

B Escabiosis; permetrina a toda la familia

C Varicela; aciclovir

D Impétigo; mupirocina

E Dermatitis atópica; inmunomoduladores tópicos

Respuesta A. Pápulas seropápulas pruriginosas agrupadas en zonas expuestas, en brotes estacionales y en grupos de 3 (desayuno, almuerzo y cena), corresponden a prúrigo por picadura de insectos (pulgas, mosquitos), una reacción de hipersensibilidad. Se maneja con antihistamínicos, corticoide tópico, repelentes y control ambiental. La sarna afecta pliegues y a los convivientes.

▶ VER CLASE 6.01.1.024 Psoriasis

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.5 · Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Psoriasis: placas eritematosas bien delimitadas con escamas gruesas blanco-nacaradas en codos, rodillas, región lumbosacra y cuero cabelludo, bilaterales y simétricas. Uñas: pitting, mancha en gota de aceite, onicólisis.
- Confirmación clínica con raspado de Brocq: signo de la bujía → membrana de Duncan-Dulck → signo de Auspitz (rocío sangrante, patognomónico). Fenómeno de Koebner. Formas: en placas, en gotas (post-estreptocócica), invertida, pustulosa y eritrodérmica; artritis psoriásica (IFD, dactilitis, FR negativo).
- Tratamiento inicial según superficie: <10 % corticoide potente (clobetasol/betametasona) + calcipotriol (máx. 100 g/semana) y emolientes. >10 % o compromiso articular: derivar (GES psoriasis moderada-grave: fototerapia UVB banda angosta, metotrexato semanal + ácido fólico, biológicos tras descartar TBC latente).
- Regla de oro: NUNCA corticoides sistémicos (orales o IM) en psoriasis; su suspensión desencadena rebote pustuloso generalizado o eritrodermia. Acitretina: teratógena hasta 3 años tras suspender.
- Seguimiento completo: controles periódicos, evaluar comorbilidades (síndrome metabólico, artritis) y derivar formas graves, pustulosas o eritrodérmicas (hospitalizar).

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 120

Mujer de 35 años con placas eritematosas bien delimitadas, cubiertas de escamas plateadas en rodillas y codos, con fenómeno de Auspitz positivo. Compromete el 10% de la superficie corporal. **¿Cuál es el diagnóstico?**

A Psoriasis en placas

B Dermatitis atópica

C Dermatitis de contacto

D Liquen plano

E Micosis fungoide

Respuesta A. Placas eritematosas con escamas plateadas en superficies extensoras más fenómeno de Auspitz positivo (sangrado puntiforme al retirar la escama) es psoriasis en placas. Un compromiso del diez por ciento corresponde a psoriasis moderada.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 42 años consulta por placas eritematosas pruriginosas en ambos codos, región sacra y cuero cabelludo desde hace 2 años. Al examen físico se aprecian placas solevantadas de 4 a 6 cm de diámetro, bien delimitadas, cubiertas por escamas gruesas blanco-nacaradas. Al raspar con un abatelenguas, se desprenden virutas blanquecinas, luego una membrana transparente continua, y finalmente aparece un punteado hemorrágico fino en gotitas sobre la superficie desnudada. El compromiso estimado de superficie corporal es del ocho por ciento. **¿Cuál es la conducta terapéutica inicial más adecuada?**

A Prednisona oral en dosis decreciente por 2 semanas

B Corticoide tópico de alta potencia combinado con calcipotriol

C Metotrexato oral semanal más ácido fólico

D Anticuerpo monoclonal anti-interleucina 17

E Antibiótico oral de amplio espectro por 10 días

Respuesta B. El raspado metódico de Brocq con signo de Auspitz confirma psoriasis vulgar en placas. Con un compromiso del ocho por ciento de superficie corporal, es psoriasis leve, cuya primera línea es la terapia tópica combinada de corticoide potente más calcipotriol. El metotrexato y los biológicos son para formas moderadas a graves; el antibiótico es para la forma guttata; y la prednisona oral está formalmente contraindicada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 88

Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso, consulta por aparición de placas eritematodescamativas en las rodillas y los codos. El diagnóstico más probable es:

A Dermatittis de contacto

B Psoriasis vulgar

C Tiña corporis

D Pitiriasis rosada de Gibert

E Dermatitis atópica

Respuesta B. Diagnóstico: Psoriasis vulgar (opción B). Cuadro clásico. La psoriasis vulgar es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel de origen autoinmune que afecta aproximadamente al dos por ciento de la población mundial.

▶ VER CLASE 6.01.1.025 Reacciones cutáneas por drogas (rush, toxidermia fija)

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.10 · Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Exantema morbiliforme (rush) por fármacos: máculas y pápulas confluentes pruriginosas en tronco que se extienden a extremidades, 1–2 semanas después de iniciar el fármaco (antibióticos, AINE, anticonvulsivantes); sin fiebre alta, mucosas ni ampollas.
- Toxidermia fija (eritema pigmentado fijo): placa redonda eritematoviolácea, con ardor, que reaparece siempre en el mismo sitio horas después de reexponerse al mismo fármaco (AINE, cotrimoxazol, tetraciclinas) y deja mancha café grisácea residual.
- Específico: diagnóstico clínico con cronología fármaco–lesión; la reexposición confirma. Buscar banderas rojas de gravedad (fiebre alta, edema facial, dolor cutáneo, ampollas, Nikolsky positivo, compromiso de mucosas, eosinofilia o transaminasas) que obligan a pensar en DRESS, SSJ/NET.
- Tratamiento inicial: suspender el fármaco sospechoso y evitarlo en el futuro (registrar en la ficha), antihistamínico oral, corticoide tópico de mediana potencia y emolientes; corticoide oral breve solo en formas extensas.
- Seguimiento completo: control de la resolución, educación al paciente y derivar a alergología si se necesita pruebas o alternativas terapéuticas.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 30 años consulta por tercera vez en un año por una mancha redonda de 3 cm en el dorso de la mano, eritematoviolácea, con ardor, que aparece siempre en el mismo sitio unas horas después de tomar ibuprofeno por dismenorrea. Al resolverse deja una mancha café grisácea. No tiene compromiso de mucosas ni fiebre. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Eritema multiforme menor

B Dermatitis de contacto alérgica

C Urticaria aguda

D Síndrome de Stevens-Johnson

E Eritema pigmentado fijo

Respuesta E. La toxidermia fija o eritema pigmentado fijo es una placa eritematoviolácea que reaparece siempre en el mismo sitio tras reexponerse al mismo fármaco, típicamente AINEs, cotrimoxazol o tetraciclinas, y deja hiperpigmentación residual. El tratamiento es suspender y evitar el fármaco.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 60 años, con insuficiencia renal crónica, inició alopurinol hace 5 semanas por una crisis de gota. Consulta por fiebre de 39 °C de 4 días, edema facial marcado y un exantema morbiliforme confluente en tronco y extremidades, sin ampollas ni desprendimiento. Tiene adenopatías cervicales y axilares sensibles. El hemograma muestra 2.800 eosinófilos por microlitro y linfocitos atípicos; GOT y GPT están 8 veces sobre lo normal. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?**

A Urticaria aguda por alopurinol; antihistamínico H1 de segunda generación

B Síndrome DRESS por alopurinol; suspender el fármaco e iniciar prednisona oral

C Síndrome de Stevens-Johnson; traslado a Centro de Quemados

D Hepatitis viral aguda; solicitar serología y observar

E Eritema multiforme major; aciclovir oral

Respuesta B. Latencia de 5 semanas, fiebre, edema facial, adenopatías, eosinofilia marcada con linfocitos atípicos y hepatitis tóxica: Síndrome DRESS por alopurinol. La conducta es suspender el fármaco e iniciar prednisona oral, con descenso lento. No hay ampollas ni Nikolsky positivo para pensar en SSJ.

▶ VER CLASE 6.01.1.026 Rosácea

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.3 · Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico

QUÉ HAY QUE SABER

- Rosácea: eritema centrofacial persistente con flushing, telangiectasias y, según subtipo, pápulas/pústulas, rinofima o compromiso ocular; mujeres adultas de piel clara. NUNCA hay comedones (si los hay es acné).
- Subtipos: 1 eritematotelangiectásico, 2 pápulo-pustuloso, 3 fimatoso (rinofima, en hombres), 4 ocular (blefaritis, chalazión recurrente). Desencadenantes: sol, calor, alcohol, picantes, estrés.
- Tratamiento inicial: fotoprotección FPS ≥50 diaria, evitar gatillantes y emolientes suaves. Eritema/flushing: brimonidina tópica; pápulo-pustulosa leve: metronidazol o ivermectina tópica; moderada-severa: doxiciclina oral dosis antiinflamatoria 8–12 semanas.
- Corticoide tópico está contraindicado (mejora por vasoconstricción y luego rebote: rosácea esteroidal, atrofia). Rinofima establecido: cirugía o láser CO2; ocular: higiene palpebral y lágrimas artificiales.
- Seguimiento completo por médico general; derivar rinofima, compromiso ocular o falta de respuesta.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 61

Una paciente de 30 años consulta por aparición de eritema, pápulas y pústulas en ambas mejillas, de varios meses de evolución, que aumentan con la exposición solar. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Acné del adulto

B Rosácea

C Dermatomiositis

D Erupción polimorfa solar

E Lupus cutáneo crónico

Respuesta B. Eritema con pápulas y pústulas en mejillas que empeora con el sol: rosácea. El acné del adulto tendría comedones; la dermatomiositis daría otros signos cutáneos y debilidad muscular; la erupción polimorfa solar no tiene pústulas; el lupus cutáneo crónico es una o más placas de curso más lento, sin tantas pústulas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 38 años de tez clara consulta por enrojecimiento persistente en mejillas y nariz de 1 año de evolución, que empeora al tomar café caliente, beber vino tinto o salir al sol. En el último mes aparecieron pápulas y pústulas milimétricas en mejillas y dorso nasal, con telangiectasias visibles. No se identifican comedones en ninguna zona del rostro. **¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?**

A Clobetasol tópico de alta potencia por 2 semanas

B Adapaleno tópico en monoterapia

C Fotoprotección, evitar desencadenantes y metronidazol tópico

D Doxiciclina oral 100 mg al día de forma indefinida

E Isotretinoína oral por su componente pustuloso

Respuesta C. Eritema centrofacial que empeora con calor, alcohol y sol, con telangiectasias y pápulo-pústulas, sin comedones: rosácea pápulo-pustulosa. La primera línea es fotoprotección, evitar desencadenantes y metronidazol o ivermectina tópica. El corticoide está contraindicado; el adapaleno y la isotretinoína son de acné; la doxiciclina se reserva para formas moderadas-severas y por tiempo acotado.

▶ VER CLASE 6.01.1.027 Sarna

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.16 · Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Sarna (escabiosis, Sarcoptes scabiei): prurito intenso de predominio nocturno que afecta a varios convivientes; contagio por contacto piel con piel.
- Lesiones: surco acariano (línea fina serpenteante con vesícula perlada) en espacios interdigitales, cara anterior de muñecas, axilas, areolas, ombligo y genitales (nódulos escabióticos); respeta cara y espalda en el adulto, pero en lactantes puede afectar cuero cabelludo, palmas y plantas.

- Confirmación: acarotest (raspado del surco con visualización del ácaro, huevos o fecas); un resultado negativo no la descarta.
- Tratamiento: permetrina 5 % crema de cuello a pies, dejar 8–12 horas, repetir a los 7 días; ivermectina oral 200 µg/kg como alternativa. Tratar a TODOS los convivientes y contactos a la vez, tengan o no síntomas; lavar ropa de cama a >60 °C o aislar 72 horas en bolsa.
- Seguimiento completo: el prurito puede persistir 2–4 semanas tras curar; reevaluar si hay lesiones nuevas, tratar impétigo secundario y notificar brotes (institucionales).

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niña de 9 años consulta con su madre por prurito intenso de predominio nocturno, de 3 semanas de evolución, que también afecta a su hermano menor. Al examen se aprecian pápulas eritematosas con pequeños surcos lineales en los espacios interdigitales de ambas manos y en la cara anterior de las muñecas. **¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?**

A Permetrina al 5% en la niña, dejando al hermano en observación por ahora

B Permetrina al 5% simultánea en la niña y en todos los convivientes del hogar

C Corticoide tópico de alta potencia para el prurito, y control en 2 semanas

D Antihistamínico oral exclusivo, sin tratamiento tópico

E Ivermectina oral solo si el acarotest resulta positivo

Respuesta B. Prurito nocturno con surcos acarianos interdigitales, que afecta a más de un miembro de la familia: escabiosis. El tratamiento de elección es permetrina al 5% aplicada de forma simultánea a todos los convivientes, tengan o no síntomas, para evitar la reinfección.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 17

Un paciente de 35 años consulta por intenso prurito en la zona genital de una semana de evolución. Al examen físico, se observan lesiones escrotales, que se muestran en la imagen (fuente: https://rafalafena.wordpress.com/wp- content/uploads/2022/03/....). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Prúrigo nodular

B Infección por virus papiloma humano

C Sífilis primaria

D Escabiosis

E Sífilis secundaria

Respuesta D. Sarna Nodular: La presencia de prurito en la zona genital puede ser compatible con escabiosis (sarna) o infestación por ladillas (Phthirus pubis). Sin embargo, si las imágenes muestran lesiones nodulares características, se confirma el diagnóstico de sarna nodular.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 108

Embarazada de 30 semanas, sin antecedentes, consulta por lesiones eritematosas en antebrazos, genitales, manos y tronco, asociadas a prurito. Al examen físico se aprecian lesiones eritematosas pápulares y maculares en patrón sinuoso, con signos de grataje, por lo que se decide realizar un ácaro test, que resulta positivo. El tratamiento de elección, en este caso es:

A Permetrina oral

B Puvaterapia

C Corticoides locales

D Permetrina tópica al 5%

E Vaselina azufrada

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Vaselina azufrada (opción E). Sarna en embarazo = vaselina azufrada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 91

Una mujer de 34 años, cursando embarazo de 23 semanas, presenta lesiones pruriginosas en abdomen, manos y zona inguinal, que han ido en aumento en la última semana. Al examen físico se aprecian signos de rascado, pápulas y surcos en la zona interdigital y antebrazos. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A Betametasona tópica

B Vaselina azufrada tópica

C Loción de permetrina 5% tópica

D Ivermec2na oral

E Prednisona oral

Respuesta B. Es una pregunta discutible. La normativa chilena vigente es muy antigua (Norma técnica 101 Minsal del año 2007, aunque ha sido replicada en normas más actuales) y aún prioriza la vaselina azufrada por su inocuidad total en embarazadas, lactancia y niños menores de 2 meses (por eso la dejaremos como correcta, ya que probablemente fue la correcta en el examen). Sin embargo, la evidencia moderna es clara en que la permetrina al 5% es actualmente el tratamiento de elección incluso en embarazadas y...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 4

Clínica de Sarna (perlada) con acarotest negativo manejo:

A Permetrina
B Ivermectina
C Repetir acarotest
D Vaselina azufrada
E Amoxicilina

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Permetrina (opción A).

▶ VER CLASE 6.01.1.028

Tumores benignos de piel (quistes, lipomas, queratosis seborreica)

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.17 · Tumores Benignos de Piel, Hemangiomas Infantiles y Malformaciones Vasculares

QUÉ HAY QUE SABER

- Quiste epidérmico (infundibular): nódulo subcutáneo móvil, firme, con punto central (comedón) que drena material caseoso maloliente; puede inflamarse o infectarse (absceso). Tratamiento: exéresis completa de la cápsula en frío; si está infectado, drenaje y exéresis diferida.
- Lipoma: tumor de grasa blando, lobulado, móvil, indoloro, de crecimiento lento; exéresis si es sintomático, crece o es mayor de 5 cm (sospecha de liposarcoma si es profundo, firme y de crecimiento rápido: ecografía/RM antes de operar).
- Queratosis seborreica: placas pigmentadas, de aspecto «pegado», untuoso y verrugoso, en tronco de adultos mayores; benigna. Signo de Leser-Trélat: aparición brusca de múltiples lesiones, sospecha de neoplasia interna.
- Tratamiento completo: queratosis seborreica solo por razones estéticas o irritación (crioterapia, curetaje); en lesión dudosa u oscura realizar biopsia (diferencial con melanoma). Enviar a histología toda pieza extirpada.
- Seguimiento completo: control de la herida y recidiva; derivar a cirugía si es profundo, mayor de 5 cm, de crecimiento rápido o en localización de riesgo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 83

Paciente de 24 años presenta una cicatriz de gran tamaño en la zona esternal, secundaria a una cirugía torácica realizada hace 6 meses, que no ha respondido a la terapia compresiva. Al examen físico se observa una cicatriz que sobrepasa los bordes de la herida inicial, de aspecto rojo-violáceo y dolorosa a la palpación. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Cicatriz hipertrófica en fase activa
B Queloide
C Cuerpo extraño
D Úlcera de Marjolin
E Granuloma piógeno

Respuesta B. El queloide es una proliferación fibrosa benigna que sobrepasa los límites de la herida original, no regresa espontáneamente y predomina en zona esternal, hombros y lóbulos auriculares. La cicatriz hipertrófica se mantiene dentro de los bordes y tiende a mejorar. El tratamiento incluye corticoides intralesionales, presoterapia y silicona; la exéresis aislada recidiva.

▶ VER CLASE 6.01.1.029

Tumores premalignos (queratosis actínicas, Bowen)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.15 · Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Queratosis actínica: lesión premaligna más frecuente; mácula o pápula eritematosa poco delimitada con escama seca adherente, áspera «como papel de lija» (se palpa antes de verse), en cara, orejas, dorso de manos, antebrazos y cuero cabelludo calvo; por radiación UV acumulada (mutación TP53). Es un carcinoma espinocelular in situ incipiente.
- Cuerno cutáneo: protrusión hiperqueratósica cónica; ~60 % tiene una QA en la base y ~20 % esconde un espinocelular: biopsiar siempre la base. Alarma: base indurada, dolor, crecimiento rápido o ulceración sugiere carcinoma invasor.
- Enfermedad de Bowen: placa eritematoescamosa bien delimitada y lenta, carcinoma espinocelular in situ; se biopsia y trata (crioterapia, 5-FU, imiquimod, extirpación). Nevo displásico: marcador de riesgo de melanoma, no cáncer; biopsia excisional si atipia marcada o cambios; si atipia leve y estable, seguimiento fotográfico.
- Tratamiento inicial: lesión aislada → crioterapia con nitrógeno líquido; múltiples lesiones o campo de cancerización → imiquimod 5 % o 5-fluorouracilo 5 % tópico (el eritema intenso indica respuesta), más fotoprotección estricta.
- Seguimiento completo: control periódico de la piel fotoexpuesta, educación en fotoprotección y derivar lesiones sospechosas de progresión.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 65 años presenta en la frente y dorso de manos varias máculas eritematosas milimétricas cubiertas por escamas ásperas muy adherentes, que al frotarlas suavemente con el dedo se sienten rugosas como lija. No hay induración ni signos inflamatorios profundos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Queratosis actínicas

B Queratosis seborreicas

C Psoriasis vulgar

D Lupus eritematoso discoide

E Linfoma cutáneo de células T

Respuesta A. Máculas eritematosas poco delimitadas con escamas adherentes ásperas al tacto (signo de la lija) en zonas fotoexpuestas crónicas son patognomónicas de las queratosis actínicas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 68 años, agricultora, consulta por múltiples lesiones ásperas de 3 a 5 mm en mejillas, nariz y dorso de ambas manos, que nota "como escamas que no se despegan". Al tacto, la piel se siente rugosa, como papel de lija. Ninguna lesión tiene base indurada ni ha crecido rápido en el último tiempo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Crioterapia focal sobre cada lesión, una por una, sin más medidas

B Combinar crioterapia en las más gruesas con Imiquimod o 5-Fluorouracilo en el campo, más fotoprotección estricta

C Biopsia excisional de todas las lesiones antes de decidir tratamiento

D Observación clínica sin tratamiento, con control en un año

E Corticoide tópico de alta potencia por 4 semanas

Respuesta B. Múltiples queratosis actínicas en zonas fotoexpuestas extensas corresponden a un campo de cancerización. El tratamiento combina destrucción focal de las lesiones más gruesas (crioterapia) con tratamiento médico del campo completo (Imiquimod o 5-Fluorouracilo) y fotoprotección estricta. No hay signos de alarma que justifiquen biopsiar todas las lesiones.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 81

Un paciente de 72 años, con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en hemodiálisis, presenta aparición de una lesión en la cara anterior de la pierna derecha, eritematosa y descamativa, que inició hace cerca de 12 meses y ha ido aumentando progresivamente de tamaño. Al examen físico se observa la siguiente lesión: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Psoriasis

B Derma22s de contacto

C Eccema numular

D Enfermedad de Bowen

E Tiña

Respuesta D. Si bien por la ubicación y aspecto se podía pensar en una psoriasis, la edad, la evolución y la presencia de una única lesión es característica de la enfermedad de Bowen, que es un cáncer espinocelular in situ. Fuente imagen: hxps://iqb.es/dermatologia.

▶ VER CLASE 6.01.1.030 **Urticaria aguda** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.8 · Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Urticaria aguda (<6 semanas): habones pruriginosos, sobreelevados, con halo pálido y evanescentes (cada lesión <24 h, sin dejar marca); degranulación de mastocitos. Causas: infecciones virales (lo más frecuente, sobre todo en niños), fármacos (AINE, antibióticos) y alimentos.
- Confirmar: diagnóstico clínico; preguntar cuánto dura cada habón. Si el habón es fijo >24–48 h, deja púrpura o duele/arde, pensar en vasculitis urticariana y biopsiar. No requiere estudio alérgico de rutina (prick/IgE) en urticaria aguda.
- Tratamiento completo: suspender el gatillante y dar antihistamínico H1 de segunda generación (cetirizina, levocetirizina, desloratadina, loratadina) a dosis estándar; corticoide oral en ciclo ultracorto (3–5 días) solo en casos extensos o refractarios.
- Descartar anafilaxia (compromiso respiratorio, hemodinámico o digestivo): ahí la primera medida es adrenalina IM, no antihistamínicos.
- Seguimiento completo: control del cuadro; si persiste ≥6 semanas es urticaria crónica (antihistamínico hasta 4 veces la dosis, luego omalizumab: derivar).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 20

Mujer de 28 años con urticaria generalizada de 48 horas de evolución, con prurito intenso. Sin angioedema ni compromiso hemodinámico. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A Levocetirizina oral

B Adrenalina subcutánea

C Metilprednisolona endovenosa

D Omalizumab subcutáneo

E Inmunoterapia sublingual

Respuesta A. Urticaria aguda sin signos de anafilaxia: la primera línea son los antihistamínicos H1 de segunda generación, como la levocetirizina. Los corticoides se reservan para casos refractarios y de rescate, no como primera línea.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 32 años consulta por aparición recurrente de ronchas solevantadas, rojizas y muy pruriginosas en el tronco y las extremidades desde hace 3 meses, casi todos los días. Cada roncha individual dura entre 4 y 6 horas y desaparece sin dejar ninguna cicatriz ni marca, pero brotan otras nuevas en sitios diferentes. Ha usado desloratadina 5 miligramos al día sin lograr mejoría satisfactoria. No hay angioedema ni compromiso respiratorio. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar prednisona oral de mantenimiento por 3 meses

B Aumentar la dosis del antihistamínico H1 hasta 4 veces la dosis estándar

C Solicitar biopsia cutánea de inmediato

D Administrar adrenalina intramuscular

E Cambiar a un antihistamínico de primera generación como la clorfenamina

Respuesta B. Habones evanescentes, diarios, de más de 6 semanas de evolución, sin respuesta a dosis estándar de antihistamínico H1: urticaria crónica espontánea refractaria. El siguiente escalón según las guías internacionales es cuadruplicar la dosis del mismo antihistamínico H1 de segunda generación, no cambiar a corticoides ni a antihistamínicos sedantes de primera generación.

▶ VER CLASE 6.01.1.031 Verrugas, herpes simplex, herpes zoster, moluscos

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.12 · Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple

QUÉ HAY QUE SABER

- Verrugas (VPH): verruga vulgar = pápula hiperqueratósica rugosa con puntos negros (capilares trombosados) en manos y periungueal; plantar con dolor; plana en cara; condiloma acuminado exofítico anogenital (distinto del condiloma plano de la sífilis). Tratamiento: ácido salicílico tópico, crioterapia con nitrógeno líquido; condilomas con podofilotoxina o imiquimod.
- Molusco contagioso (poxvirus): pápulas perladas con umbilicación central en niños; autolimitado en meses; tratar con curetaje, crioterapia o hidróxido de potasio si se desea.
- Herpes simple: vesículas agrupadas sobre base eritematosa en labio (VHS-1) o genitales (VHS-2), precedidas de ardor; confirmar clínicamente (Tzanck o PCR). Aciclovir oral 400 mg cada 8 horas por 7–10 días o aciclovir tópico en herpes labial precoz; supresión si hay ≥6 recurrencias al año.
- Herpes zóster: reactivación del VVZ, dolor urente seguido de vesículas en racimo en un dermatoma unilateral que no cruza la línea media; aciclovir 800 mg 5 veces al día por 7 días (o valaciclovir 1 g cada 8 horas), idealmente en las primeras 72 horas; neuralgia postherpética con pregabalina, gabapentina o amitriptilina.
- Seguimiento completo: derivar zóster oftálmico (signo de Hutchinson) o Ramsay-Hunt, inmunosuprimidos con lesiones extensas y verrugas o condilomas refractarios.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 86

Un niño de 8 años presenta una lesión en la cara lateral del primer ortejo derecho. Al examen físico se aprecia una lesión hiperqueratósica, de superficie rugosa, con puntos negros en su superficie. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Queratosis seborreica

B Melanoma

C Panadizo

D Verruga vulgar

E Cuerpo extraño periungueal

Respuesta D. Una pápula hiperqueratósica rugosa con puntos negros, que son capilares trombosados, en la zona periungueal de un niño es una verruga vulgar por virus papiloma humano. La queratosis seborreica es del adulto mayor y el panadizo es una infección aguda dolorosa con pus.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 177

Un paciente de 23 años consulta por aparición de lesiones dolorosas y pruriginosas en los pies, que aparecieron hace un mes y han aumentado. Al examen físico, se aprecia lo siguiente (fuente: podologíapriego): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Tiña pedis
B Verrugas plantares
C Granuloma piógeno
D Queratosis seborreica
E Molusco contagioso

Respuesta B. Diagnóstico: Verrugas plantares (opción B). Son verrugas plantares clásicas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 89

Adolescente de 20 años, consulta por la siguiente lesión, en el pliegue interglúteo, que presenta prurito y ardor: El diagnóstico más probable es:

A Picadura de insecto
B Consilomas acuminadas
C Herpes simplex
D Impétigo ampollar
E Erisipela

Respuesta C. Diagnóstico: Herpes simplex (opción C). Imagen clásica. Es una recurrencia de herpes genital probablemente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 43

Un paciente adulto mayor, diabético, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de aparición de una lesión eritematosa en el tronco, como se ve en la siguiente imagen: El tratamiento más adecuado es:

A Aciclovir 400 mg cada 8 horas, por 5 días
B Valaciclovir 1g cada 8 horas, por 5 días
C Aciclovir tópico
D Loratadina 10 mg al día por 5 días
E Flucloxacilina 500 mg cada 8 horas por 10 días

Respuesta B. Tiene un herpes zóster. Sirven tanto el aciclovir, como el valaciclovir, pero solo la dosis del valaciclovir estaba bien, porque la de aciclovir, para herpes zóster es 800 mg cada 4 horas, por 5 a 7 días.

▶ VER CLASE 6.01.1.032 **Vitiligo** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.1 · Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel

QUÉ HAY QUE SABER

- Vitiligo: enfermedad autoinmune con destrucción de melanocitos; máculas acrómicas (blancas) de bordes netos, sin descamación, simétricas en dorso de manos, periorificiales (boca, ojos), codos, rodillas y genitales; se acentúan con luz de Wood. Fenómeno de Koebner positivo.
- Asociación con autoinmunidad: tiroiditis de Hashimoto, diabetes tipo 1, anemia perniciosa, alopecia areata y enfermedad de Addison; pedir TSH y glicemia. Diferencial: pitiriasis versicolor (hipocrómica, descama al raspar), pitiriasis alba, lepra, hipopigmentación postinflamatoria.
- Tratamiento inicial: fotoprotección estricta de las zonas despigmentadas (riesgo de quemadura), corticoide tópico de mediana-alta potencia o inhibidor de calcineurina tópico (tacrolimus) en cara y pliegues.
- Fototerapia UVB de banda angosta en formas extensas o progresivas (especialista); camuflaje cosmético y apoyo psicológico.
- Seguimiento: derivar a dermatología para fototerapia o formas extensas; la repigmentación es lenta (meses) e incompleta en manos y pies.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 30 años con manchas blancas de 1 año, simétricas, en dorso de manos, alrededor de la boca y en ambos codos. Son máculas acrómicas de bordes netos, sin descamación, que se acentúan con la luz de Wood. Tiene hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Pitiriasis versicolor
B Lepra tuberculoide
C Hipopigmentación postinflamatoria
D Pitiriasis alba
E Vitiligo

Respuesta E. Máculas acrómicas (sin melanina), de bordes netos, simétricas en zonas periorificiales y acrales, que se intensifican con luz de Wood, son vitiligo, enfermedad autoinmune asociada a tiroiditis, diabetes tipo 1 y anemia perniciosa. Se trata con corticoides o inhibidores de calcineurina tópicos y fototerapia. La pitiriasis versicolor es hipocrómica y descama al rascado.

▶ VER CLASE 6.01.1.033 **Vasculitis cutáneas** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.22 · Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

QUÉ HAY QUE SABER

- Vasculitis cutánea de vaso pequeño (leucocitoclástica): púrpura palpable (pápulas purpúricas que no desaparecen a la vitropresión) en piernas y nalgas, a veces con ampollas o necrosis; aparece 1–3 semanas tras infección o fármaco (antibióticos, AINE).
- Púrpura de Henoch-Schönlein (vasculitis IgA): púrpura palpable en extremidades inferiores y nalgas con plaquetas normales, artralgias, dolor abdominal cólico y nefritis; ANCA negativos. Habitualmente en niños tras infección respiratoria.
- Sospecha: toda púrpura palpable obliga a buscar compromiso sistémico (orina con hematuria/proteinuria, creatinina, presión arterial) y causa (fármacos, infecciones, crioglobulinemia, hepatitis B y C, autoinmune); biopsia de lesión de <48 h con inmunofluorescencia confirma.
- Tratamiento inicial: suspender fármaco sospechoso, reposo y elevar extremidades, analgesia con paracetamol; Henoch-Schönlein es autolimitado (4–6 semanas), prednisona 1 mg/kg solo en dolor abdominal intenso o sangrado; ANCA (GPA/PAM): corticoides en pulsos + rituximab/ciclofosfamida y profilaxis con cotrimoxazol (especialista).
- Seguimiento: derivar a reumatología o nefrología si hay compromiso sistémico; en Henoch-Schönlein controlar orina y presión arterial por 6 meses. Habón fijo >24 horas que deja púrpura sugiere vasculitis urticariana.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 40 años con lesiones en ambas piernas de 5 días, que aparecieron 1 semana después de iniciar amoxicilina por una sinusitis. Al examen se observan pápulas purpúricas palpables, que no desaparecen a la vitropresión, en ambas piernas y tobillos. Plaquetas normales, función renal y sedimento urinario normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?**

A Púrpura trombocitopénica inmune; corticoides

B Vasculitis leucocitoclástica (de pequeño vaso) por fármacos; suspender el antibiótico y confirmar con biopsia de piel

C Meningococcemia; ceftriaxona

D Escorbuto; vitamina C

E Dermatitis de contacto; corticoide tópico

Respuesta B. La púrpura palpable en extremidades inferiores con plaquetas normales es la lesión típica de la vasculitis cutánea de pequeño vaso (leucocitoclástica), frecuentemente por fármacos o infecciones. Se suspende el agente gatillante, se confirma con biopsia y se buscan compromiso renal, digestivo y articular. La púrpura de la trombocitopenia no es palpable.

Situaciones clínicas de urgencia

16 códigos

▶ VER CLASE 6.01.2.001 **Angioedema de Quinque** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.8 · Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Angioedema: edema profundo (dermis profunda, subcutáneo, submucosa) de labios, párpados, lengua, genitales o laringe; tumefacción tensa que duele o tensa más que pica, y tarda 2–3 días en reabsorberse. Puede acompañar a la urticaria.
- Causas: alérgico/histaminérgico (alimentos, fármacos como AINE), por IECA (bradicininérgico, sin habones, no responde a antihistamínicos) y hereditario por déficit de inhibidor de C1 esterasa (C4 bajo, sin prurito ni habones).
- Bandera roja: disfonía, estridor, disnea, sensación de cierre de garganta, lengua hinchada o hipotensión = vía aérea en riesgo / anafilaxia.
- Tratamiento inicial: adrenalina IM 0,5 mg en adultos (0,01 mg/kg en niños) en cara anterolateral del muslo, repetible a los 5–15 min; asegurar vía aérea, O2 y vía venosa; antihistamínicos y corticoides EV solo como coadyuvantes. Suspender IECA/AINE. En angioedema hereditario: inhibidor de C1 o icatibant.
- Seguimiento: derivar/hospitalizar a unidad de urgencia; luego estudio etiológico por inmunología/alergología (C4, C1 inhibidor).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 28 años consulta 30 minutos después de comer mariscos por hinchazón progresiva de labios y lengua, con voz ronca y sensación de cierre de la garganta. Presión arterial 118/76, frecuencia cardíaca 104, saturación 95%. No tiene habones. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Clorfenamina oral y observación

B Inhibidor C1 esterasa endovenoso

C Prednisona oral y control al día siguiente

D Adrenalina 0,5 mg intramuscular en la cara anterolateral del muslo

E Alta con loratadina por 7 días

Respuesta D. Angioedema alérgico de labios y lengua con disfonía y sensación de cierre faríngeo indica compromiso de la vía aérea: es una emergencia. El tratamiento inmediato es adrenalina intramuscular, 0,5 mg en el adulto, en el muslo, repetible a los 5 a 15 minutos. Antihistamínicos y corticoides son coadyuvantes y no la reemplazan.

▶ VER CLASE 6.01.2.002 Ántrax

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.1 · Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Ántrax (carbunco estafilocócico, no el Bacillus anthracis): confluencia de varios forúnculos por S. aureus que forma una placa indurada muy dolorosa con múltiples orificios de drenaje («en espumadera»), típica en nuca y espalda de diabéticos.
- Sospecha: placa dolorosa >3–5 cm con pus por varios orificios, fiebre y malestar; factores: diabetes mal controlada, obesidad, inmunosupresión.
- Tratamiento inicial: drenaje quirúrgico (incisión y desbridamiento) más antibiótico sistémico antiestafilocócico (cloxacilina o cefazolina endovenosa; cubrir SAMR con cotrimoxazol, clindamicina o vancomicina según riesgo), analgesia y control de la glicemia.
- Hospitalizar si hay fiebre, diabetes descompensada, localización facial o extensión; tomar Gram y cultivo con antibiograma.
- Seguimiento: derivar a cirugía/dermatología para drenaje y curaciones; estudiar diabetes e inmunosupresión si no se conocían.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 60 años, diabético mal controlado, consulta por una placa indurada, muy dolorosa, de 6 cm en la nuca, con múltiples orificios por los que drena pus (aspecto en espumadera), de 5 días. Tiene fiebre de 38,5 °C. **¿Cuál es el diagnóstico y el manejo más adecuado?**

A Forúnculo simple; calor local

B Carbunco por Bacillus anthracis; ciprofloxacino y notificación

C Ántrax (carbunco estafilocócico); drenaje quirúrgico, antibiótico sistémico antiestafilocócico y control de la glicemia

D Quiste epidérmico infectado; exéresis electiva

E Hidradenitis supurativa; doxiciclina

Respuesta C. El ántrax es la confluencia de varios forúnculos (S. aureus) que forman una placa inflamatoria con múltiples bocas de drenaje, típico en nuca y espalda de diabéticos. Es una infección profunda que requiere drenaje y antibiótico sistémico (cloxacilina o cefazolina, o según riesgo de SAMR) y compensación metabólica. El carbunco por B. anthracis es una escara negra indolora.

▶ VER CLASE 6.01.2.003 Erisipela / Celulitis

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.1 · Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Erisipela: dermis superficial y linfáticos, S. pyogenes (>90 %); placa roja brillante, caliente, en «piel de naranja», con borde neto y sobreelevado, inicio brusco con fiebre alta y calofríos; piernas y cara (alas de mariposa). Linfedema es factor de riesgo.
- Celulitis: dermis profunda y subcutáneo, S. aureus y S. pyogenes; eritema, calor y edema con fóvea de bordes difusos, planos y mal delimitados; progresión en 24–48 horas. Buscar la puerta de entrada (tinea pedis, úlcera, herida).
- Tratamiento ambulatorio 7–10 días: marcar el borde con lápiz y reevaluar a las 24–48 horas; cefadroxilo 500 mg cada 12 horas, cefalexina 500 mg cada 6 horas o flucloxacilina 500 mg cada 8 horas (cubren ambos agentes); alérgicos: clindamicina 300 mg cada 8 horas; sospecha de SAMR: cotrimoxazol forte. Reposo con pierna elevada. Amoxicilina no cubre bien el estafilococo.
- Hospitalizar y dar cefazolina 1 g cada 8 horas o cloxacilina 1–2 g cada 4–6 horas EV si hay SIRS/sepsis, progresión tras 48 horas, comorbilidad descompensada (diabetes, cirrosis, inmunosupresión) o celulitis facial (riesgo de trombosis del seno cavernoso). Sospechar fascitis necrotizante si hay dolor desproporcionado, ampollas o shock.
- Seguimiento completo: control de evolución, tratar la puerta de entrada y prevenir recurrencias (manejo del linfedema, penicilina benzatina profiláctica si recurre).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 137

Una paciente de 62 años presenta una caída a nivel, con erosión en la rodilla derecha. Tres días después presenta una lesión eritematosa, que rodea la herida, de 10 cm de diámetro y bordes difusos, con aumento de la temperatura local. **¿Cuál es la conducta de elección?**

A Indicar mupirocina tópica

B Realizar curación con suero fisiológico y control en 48 horas

C Realizar curaciones diarias con suero fisiológico y povidona yodada

D Indicar amoxicilina oral por 7 días

E Indicar cefadroxilo oral por 7 días

Respuesta E. Erosión como puerta de entrada + eritema de bordes difusos con calor local: celulitis. Requiere antibiótico sistémico que cubra S. aureus (cefadroxilo, flucloxacilina, cloxacilina; clindamicina en alérgicos). La amoxicilina no cubre bien al estafilococo y las medidas locales no bastan.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 58 años con linfedema crónico de la pierna derecha tras safenectomía. Hace 12 horas inicia calofríos intensos, fiebre de 39 °C y dolor ardiente en esa pierna. En la cara anterior hay una placa eritematosa extensa, rojo brillante, indurada y dolorosa, con bordes nítidos y sobreelevados. Sin colecciones ni fluctuación. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Staphylococcus aureus meticilino resistente

B Streptococcus pyogenes

C Pseudomonas aeruginosa

D Staphylococcus epidermidis

E Escherichia coli

Respuesta B. Inicio súbito con fiebre alta y calofríos, placa rojo brillante con bordes nítidos y sobreelevados, sobre un linfedema: erisipela por Streptococcus pyogenes. Conducta: marcar el borde, reposo con la pierna elevada y cefadroxilo oral (o penicilina V o flucloxacilina); si hay compromiso del estado general, hospitalizar para cefazolina o penicilina G sódica EV.

▶ VER CLASE 6.01.2.004 Eritrodermia

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.5 · Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Eritrodermia: eritema y descamación de >90 % de la superficie corporal; es una urgencia dermatológica por pérdida de calor, agua y proteínas, riesgo de insuficiencia cardíaca de alto gasto y sepsis.
- Causas: psoriasis (incluida la suspensión brusca de corticoides sistémicos), dermatitis atópica/eccema, reacciones a fármacos, linfoma cutáneo (síndrome de Sézary) e idiopática.
- Sospecha: fiebre o hipotermia, calofríos, edema de extremidades, taquicardia, adenopatías.
- Tratamiento inicial: hospitalizar, soporte (control de temperatura, balance hídrico y electrolítico, nutrición), emolientes, corticoide tópico de baja potencia, retirar fármacos sospechosos y prevenir infección. No dar corticoides sistémicos si es psoriasis.
- Seguimiento: derivar a dermatología para diagnóstico etiológico (biopsia) y tratamiento específico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 55 años con psoriasis en placas, que suspendió bruscamente prednisona oral indicada por un médico particular. Consulta por eritema y descamación de más del 90% de la superficie corporal, calofríos, temperatura de 38 °C y edema de extremidades. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Manejo ambulatorio con corticoide tópico de alta potencia en todo el cuerpo

B Antihistamínico oral y control en 1 mes

C Reiniciar prednisona en dosis altas y alta

D Hospitalización para manejo de soporte (control de temperatura, balance hídrico y electrolítico, prevención de infecciones) y tratamiento por dermatología

E Fototerapia ambulatoria

Respuesta D. La eritrodermia (eritema y descamación en más del 90% de la superficie) es una urgencia dermatológica: pérdida de calor, agua y proteínas, insuficiencia cardíaca de alto gasto e infección. Requiere hospitalización, soporte, emolientes, corticoide tópico de baja potencia y tratamiento de la causa (aquí psoriasis desencadenada por suspensión de corticoides sistémicos, que no deben usarse en psoriasis).

▶ VER CLASE 6.01.2.005 Fasceitis necrotizante

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.4 · Infecciones Invasivas de Partes Blandas y Angina de Ludwig

QUÉ HAY QUE SABER

- Fascitis necrotizante: infección rápidamente destructiva de fascia profunda y subcutáneo con trombosis microvascular. Tipo I polimicrobiana (80 %; diabéticos, cirugía perineal; gangrena de Fournier); tipo II por S. pyogenes (jóvenes tras trauma menor o varicela).
- Sospecha: dolor desproporcionado a una piel solo eritematosa, que sobrepasa los márgenes del eritema; luego signos duros: flictenas serohemáticas, crepitación, anestesia cutánea focal, piel violácea y shock séptico con lactato elevado.
- El diagnóstico es clínico: no retrasar el pabellón por imágenes ni punción. Diferencial con celulitis (dolor proporcional, hemodinamia estable).
- Tratamiento inicial: reanimación de shock séptico y traslado inmediato a pabellón para exploración, desbridamiento amplio y fasciotomía; antibióticos EV en paralelo: meropenem + vancomicina + clindamicina (la clindamicina bloquea la síntesis de toxinas estreptocócicas).
- Seguimiento: derivar y manejar en centro con cirugía y UCI; mortalidad aumenta con cada hora de demora. Angina de Ludwig (origen dental) es otra urgencia: asegurar vía aérea primero.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 50 años, diabética, con una herida en la pierna hace 3 días. Consulta por dolor intenso, desproporcionado a los hallazgos, con eritema mal delimitado, edema que se extiende más allá del eritema, ampollas violáceas y crépito a la palpación. Temperatura 39 °C, PA 90/55 mmHg, FC 120 lpm. **¿Cuál es la conducta más importante?**

A Antibiótico oral y control en 48 horas

B Resonancia magnética antes de decidir conducta

C Elevación de la extremidad y cefazolina endovenosa

D Reanimación, antibióticos endovenosos de amplio espectro y desbridamiento quirúrgico urgente

E Hospitalizar y observar la evolución de los bordes marcados

Respuesta D. Dolor desproporcionado, edema más allá del eritema, ampollas violáceas, crépito y shock son signos de fasceitis necrotizante. Es una emergencia quirúrgica: el desbridamiento precoz es el principal determinante de sobrevida, junto con antibióticos amplios (incluyendo clindamicina por efecto antitoxina) y reanimación. Las imágenes no deben retrasar la cirugía.

▶ VER CLASE 6.01.2.006 Hemangiomas y malformaciones vasculares del recién nacido

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.9 · Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemangioma infantil: aparece en los primeros días-semanas, crece rápido durante los primeros 6–12 meses y luego involuciona; malformaciones vasculares están presentes desde el nacimiento y no involucionan (capilares «mancha en vino de Oporto», venosas, linfáticas, arteriovenosas).
- Sospecha: lactante con placa o nódulo vascular rojo o azulado de crecimiento rápido; mancha en vino de Oporto en territorio V1 puede asociarse a Sturge-Weber (glaucoma, convulsiones) y síndrome de Klippel-Trenaunay en extremidades.
- Urgencia: hemangioma periorbitario que cubre la pupila, deforma la córnea o impide abrir el ojo, por riesgo de ambliopía; también vía aérea (barba), ulcerados o con falla hepática/cardíaca (hemangiomas múltiples).
- Tratamiento inicial: derivar con urgencia para iniciar propranolol oral (primera línea, 1–3 mg/kg/día, con control cardiovascular y glicemia) y evaluación oftalmológica; los pequeños y sin riesgo funcional se observan.
- Seguimiento: derivar a dermatología pediátrica/oftalmología/cirugía infantil; no usar corticoides tópicos ni esperar la involución en hemangiomas con riesgo funcional.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 6 semanas con un hemangioma infantil en el párpado superior derecho que apareció a los pocos días de vida y ha crecido rápidamente. Hoy cubre parcialmente la pupila e impide la apertura completa del ojo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Observación, ya que todos los hemangiomas involucionan

B Láser ablativo inmediato en atención primaria

C Derivar con urgencia para inicio de propranolol oral y evaluación oftalmológica por riesgo de ambliopía

D Cirugía de exéresis electiva a los 5 años

E Corticoide tópico de alta potencia

Respuesta C. Los hemangiomas infantiles crecen sobre todo en los primeros meses. Los periorbitarios que ocluyen el eje visual o deforman la córnea causan ambliopía (deprivación o astigmatismo) y requieren tratamiento precoz: propranolol oral, primera línea, iniciado por especialista. La observación solo es adecuada para hemangiomas pequeños sin riesgo funcional ni estético.

▶ VER CLASE 6.01.2.007 Herpes zoster

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.4 · Varicela No Complicada vs Complicada y Herpes Zóster

QUÉ HAY QUE SABER

- Herpes zóster: reactivación del virus varicela-zóster latente en ganglios sensitivos (por edad o inmunosupresión). Dolor neuropático urente que precede a vesículas agrupadas sobre base eritematosa en un dermatoma, estrictamente unilateral (no cruza la línea media).
- Diagnóstico clínico; confirmar con PCR o test de Tzanck solo en formas atípicas. Buscar formas especiales: zóster oftálmico (V1, signo de Hutchinson: vesículas en punta de la nariz; riesgo de queratitis y uveítis) y síndrome de Ramsay-Hunt (parálisis facial periférica, otalgia y vesículas en el conducto auditivo o pabellón).
- Tratamiento completo: aciclovir 800 mg oral 5 veces al día por 7 días, o valaciclovir 1 g cada 8 horas, idealmente en las primeras 72 horas; analgesia (paracetamol, AINE; opioides si es intenso) y curaciones. Ramsay-Hunt: aciclovir en dosis altas más corticoide oral.
- Neuralgia postherpética (dolor >3 meses): pregabalina, gabapentina o amitriptilina. Inmunosuprimidos o formas diseminadas: aciclovir endovenoso y hospitalización. Zóster oftálmico: evaluación oftalmológica urgente.
- Seguimiento completo por médico general: controlar cicatrización y dolor; indicar vacuna recombinante contra zóster en mayores de 50 años o inmunosuprimidos (donde esté disponible).

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 116

Adulto mayor con dolor en cuero cabelludo seguido de vesículas en esa zona. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A Aciclovir tópico 5% en crema
B Famciclovir 500 mg cada 8 horas por 7 días
C Prednisona oral 40 mg/día por 5 días
D Gabapentina 300 mg cada 8 horas
E Valaciclovir 1 g cada 8 horas vía oral por 7 días

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Valaciclovir 1 g cada 8 horas vía oral por 7 días (opción E). Valaciclovir 1 g cada 8 horas vía oral por 7 días. Aspirina CONTRAINDICADA en varicela (síndrome de Reye). Tratamiento: paracetamol.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 158

Una paciente de 76 años, diabética, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de aparición de una lesión eritematosa en el tronco, asociada a dolor urente, como se ve en la siguiente imagen: El tratamiento más adecuado es:

A Aciclovir 400 mg cada 8 horas, por 5 días
B Valaciclovir 1g cada 8 horas, por 7 días
C Aciclovir tópico
D Loratadina 10 mg al día por 5 días
E Flucloxacilina 500 mg cada 8 horas por 10 días

Respuesta B. El tratamiento del herpes zóster es con aciclovir 800 mg, 5 veces al día o con valaciclovir 1g c/8 horas, por un tiempo de 5 a 7 días. En cambio, los herpes simplex (genital o bucal) se tratan con la mitad de la dosis. Es muy raro que el Eunacom pregunte dosis de medicamentos, pero en esta pregunta era la única forma de elegir.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 170

Un paciente de 37 años presenta dolor en el lado derecho de la cabeza, desde hace 2 días. El día de hoy aparecen lesiones en la piel, que se muestran a continuación: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Aciclovir 400 mg cada 6 horas, vía oral por 7 días
B Fluloxacilina 500 mg cada 8 horas, vía oral por 7 días
C Prednisona 40 mg al día, vía oral por 7 días
D Mupirocina en crema al 1%, aplicar cada 8 horas, por 7 días
E Valaciclovir 1 gramo vía oral cada 8 horas, por 7 días

Respuesta E. Diagnóstico: Valaciclovir 1 gramo vía oral cada 8 horas, por 7 días (opción E). Esta clase aborda la varicela y el herpes zóster, ambos causados por el virus varicela-zóster (VVZ).

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años consulta por dolor urente en el hemitórax izquierdo desde hace 4 días. Desde hace 48 horas presenta vesículas agrupadas sobre base eritematosa que siguen una franja desde la columna hasta el esternón, sin cruzar la línea media. Está afebril, hemodinámicamente estable y no tiene inmunosupresión conocida. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Prednisona oral 1 mg/kg por 14 días como único tratamiento
B Mupirocina tópica 2 % y control en 1 semana
C Aciclovir oral 800 mg cinco veces al día por 7 días y analgesia
D Amoxicilina-ácido clavulánico oral por 7 días
E Pregabalina como único tratamiento, sin antiviral

Respuesta C. Dolor urente seguido de vesículas agrupadas en un dermatoma unilateral que no cruza la línea media corresponde a herpes zóster. El tratamiento es un antiviral oral (aciclovir 800 mg 5 veces al día por 7 días o valaciclovir 1 g cada 8 horas), idealmente en las primeras 72 horas, más analgesia. Los corticoides solos y los antibióticos no corresponden; la pregabalina se reserva para la neuralgia postherpética.

▶ VER CLASE `6.01.2.008` **Loxocelismo** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.18 · Loxoscelismo (Loxosceles laeta): Cuadro Cutáneo y Cutáneo-Visceral, Manejo y Prevención en la Vivienda

QUÉ HAY QUE SABER

- Loxoscelismo (Loxosceles laeta, «araña de rincón»): picadura habitualmente nocturna e indolora o de dolor leve al inicio, en domicilio (dormitorios, ropa, zapatos); más frecuente en verano y otoño en Chile.
- Cutáneo (más del 90 %): dolor progresivo e intenso en 2–8 horas, eritema, edema y placa livedoide violácea con ampolla; la necrosis evoluciona a escara negra y úlcera de cicatrización lenta en 1–3 semanas. Cutáneo-visceral (sistémico) en 24–72 horas: fiebre, ictericia, hemólisis, hemoglobinuria, insuficiencia renal aguda y CID.
- Diagnóstico clínico (antecedente de picadura o araña capturada y lesión característica); solicitar hemograma, LDH, bilirrubina, creatinina, orina completa y coagulación si hay sospecha de forma visceral.
- Tratamiento completo: cutáneo: reposo y elevación, frío local (no calor), analgesia, profilaxis antitetánica, aseo y curación de la úlcera; antibiótico solo si hay infección. Forma sistémica: hospitalizar con hidratación y corticoide EV, y suero antiloxoscélico si se presenta precoz (<24–48 horas) según disponibilidad.

- Seguimiento completo: control de herida hasta cicatrización y derivar a cirugía las úlceras que requieran desbridamiento o injerto; educar en prevención domiciliaria.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 89

Paciente consulta por una lesión en el antebrazo que inicialmente era dolorosa y eritematosa, pero que luego de 6 horas se volvió más oscura y más grande. Al examen físico se aprecia una placa livedoide en el antebrazo, con zonas violáceas e isquémicas alternadas con áreas pálidas y halo eritematoso. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Loxoscelismo cutáneo
B Necrosis grasa
C Ectima
D Pioderma gangrenoso
E Fasceítis necrotizante

Respuesta A. Una lesión inicialmente dolorosa que en horas evoluciona a placa livedoide (zonas violáceas, pálidas y eritematosas) es la mordedura de araña de rincón (Loxosceles laeta). Se maneja con frío local, analgesia, antihistamínico y profilaxis antitetánica, y se controla a las 24 a 48 horas buscando hemólisis y hematuria (loxoscelismo cutáneo-visceral).

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 149

Paciente con dolor en zona escapular izquierda y lesión ulcerada con halo violáceo. ¿Cuál es el agente causal más probable?

A Latrodectus mactans (araña del trigo)
B Paederus irritans (bicho candela)
C Miasis cutánea
D Loxosceles laeta (araña de rincón)
E Picadura de abeja con reacción local

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Loxosceles laeta (araña de rincón)). Loxosceles laeta (araña de rincón).

▶ VER CLASE 6.01.2.009 Necrolisis tóxica epidérmica

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.9 · Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)

QUÉ HAY QUE SABER

- Necrólisis epidérmica tóxica (Lyell): reacción grave a fármacos (sulfonamidas, alopurinol, anticonvulsivantes aromáticos, oxicams, betalactámicos) con latencia de 1–4 semanas; apoptosis masiva de la epidermis mediada por T CD8 y granulisina.
- Pródromo pseudogripal con ardor ocular, luego dianas atípicas de 2 anillos, dolor cutáneo desproporcionado, ampollas flácidas que confluyen, signo de Nikolsky positivo y compromiso de ≥2 mucosas (oral, ocular, genital). Desprendimiento >30 % de la superficie corporal = NET (SSJ <10 %; superposición 10–30 %); mortalidad 30–50 %.
- Tratamiento inicial: suspender de inmediato todo fármaco sospechoso (últimas 8 semanas), trasladar a UCI o centro de quemados, fluidoterapia, sala térmica 30–32 °C, curación con apósitos no adherentes, analgesia y nutrición.
- Calcular SCORTEN en las primeras 48 horas (edad ≥40, FC ≥120, cáncer, desprendimiento >10 %, urea >28 mg/dL, bicarbonato <20, glicemia >252). No desbridar la piel desprendida (actúa como apósito biológico).
- Interconsulta oftalmológica urgente desde el primer día (lisis de sinequias, lágrimas sin conservantes) para prevenir simblefaron. Seguimiento: derivar y manejar en centro de quemados.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 158

Una paciente de 76 años, diabética, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de aparición de una lesión eritematosa en el tronco, asociada a dolor urente, como se ve en la siguiente imagen: **El tratamiento más adecuado es:**

A Aciclovir 400 mg cada 8 horas, por 5 días
B Valaciclovir 1g cada 8 horas, por 7 días
C Aciclovir tópico
D Loratadina 10 mg al día por 5 días
E Flucloxacilina 500 mg cada 8 horas por 10 días

Respuesta B. Herpes zóster en una adulta mayor diabética: valaciclovir 1 g cada 8 horas por 7 días, o aciclovir 800 mg 5 veces al día. La opción A tiene dosis de herpes simple, insuficiente para el zóster; el tópico no sirve.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 68 años consulta por intenso dolor urente en la hemicara izquierda de 3 días de evolución, asociándose hace 24 horas a la aparición de vesículas en racimo en la frente, el párpado superior y la punta de la nariz (signo de Hutchinson positivo). **¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?**

A Iniciar Aciclovir oral a dosis plenas y solicitar evaluación urgente por Oftalmología

B Indicar tratamiento con Carbamazepina y analgesia con Paracetamol

C Aplicar ungüento tópico de corticoides en las lesiones nasales y párpado

D Administrar vacuna de refuerzo contra herpes zóster

E Realizar desbridamiento quirúrgico de las vesículas nasales

Respuesta A. Herpes zóster oftálmico con signo de Hutchinson: compromiso del nervio nasociliar (V1) que predice afectación corneal grave. Conducta: aciclovir oral (800 mg 5 veces al día) o valaciclovir, y derivación urgente a Oftalmología.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 48

Una paciente de 26 años, se realiza una colecistectomía laparoscópica hace 2 semanas. Inicialmente evoluciona bien, pero hace 12 horas presenta un cuadro de fiebre y dolor cutáneo generalizado, con eritema generalizado de la piel y compromiso de las mucosas. Hace algunas horas comienza con aparición de ampollas generalizadas. Al examen físico se observa lo mostrado en la siguiente imagen: El diagnóstico más probable es:

A Psoriasis eritrodérmica

B Escarlatina quirúrgica

C Pustulosis exantemática

D Necrosis epidermolítica tóxica

E Pénfigo

Respuesta D. Es una NET clásica, con el signo de Kikolski (se desprende la epidermis), aunque no era la imagen más característica de la NET.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 94

Un paciente de 29 años, tratado con amoxicilina por amigdalitis pultácea diagnosticada hace 14 días, presenta desde hace 3 días ardor en los ojos, lesiones en la boca, malestar general y aparición de un rash cutáneo. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival bilateral, úlceras orales y un exantema con pápulas y placas eritematosas en tronco y extremidades, con lesiones en la cara similares a las de la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Síndrome de Stevens-Johnson

B Gingivoestomatitis herpética

C Necrólisis epidérmica tóxica

D Pénfigo

E Escarlatina

Respuesta A. Síndrome de Stevens-Johnson: El cuadro clínico con compromiso de mucosas (oral, ocular), rash cutáneo con pápulas/placas eritematosas y antecedente de uso de antibiótico (amoxicilina) son característicos del síndrome de Stevens-Johnson.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 80

Una paciente de 45 años inicia tratamiento antibiótico debido a una infección dental. Al séptimo día de tratamiento presenta erupción papulovesicular generalizada y progresiva, que afecta tronco y extremidades, asociada a fiebre y malestar general. Al examen físico se aprecia lo siguiente: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Síndrome de Stevens-Johnson

B Síndrome DRESS

C Necrólisis epidérmica tóxica

D Síndrome de piel escaldada

E Pénfigo ampollar

Respuesta C. Es una NET clásica, por la extensión generalizada y el desprendimiento de la epidermis en la imagen. El SSJ es la misma patología, pero más leve, con afectación de menos del 10% de la superficie cutánea.

▶ VER CLASE 6.01.2.010 Pénfigo y penfigoide

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.11 · Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)

QUÉ HAY QUE SABER

- Pénfigo vulgar: adulto 40–60 años, úlceras orales dolorosas primero, ampollas flácidas, Nikolsky positivo, acantolisis (IgG intercelular en red de pescar). Penfigoide ampollar: anciano (>70 años), prurito previo, ampollas tensas, Nikolsky negativo, boca casi siempre respetada, depósito lineal en la membrana basal (anti-BP180/BP230).
- Diferencial urgente: SSJ/NET (fármaco, dianas atípicas, mucosas), SSSS en niños, dermatitis herpetiforme (celiaquía, vesículas agrupadas en superficies extensoras; dapsona).
- Confirmación: biopsia de ampolla reciente para histología y de piel perilesional para inmunofluorescencia directa. No biopsiar erosiones antiguas.
- Tratamiento inicial: pénfigo → prednisona oral 1–1,5 mg/kg/día ± rituximab; penfigoide → clobetasol tópico en toda la piel (menor mortalidad que prednisona en ancianos); prednisona 0,5 mg/kg/día solo si es extenso. Cuidado de erosiones, hidratación, prevención de infección.
- Seguimiento: derivar a dermatología; hospitalizar los casos extensos, con compromiso mucoso severo o ancianos frágiles.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DEL LIBRO · TEMA 16.11

Un hombre de 76 años, con antecedentes de enfermedad de Parkinson, consulta por un cuadro de 2 meses de evolución de prurito generalizado severo, al que se agregó en las últimas dos semanas la aparición de múltiples ampollas de gran tamaño en el abdomen, ingles y caras internas de muslos. Al examen físico se aprecian numerosas ampollas de contenido seroso claro, de paredes gruesas, muy tensas y duras a la palpación, asentadas sobre placas eritematosas. La mucosa oral no presenta lesiones. Al frotar con fuerza moderada la piel sana perilesional, la epidermis no se despega. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Pénfigo vulgar

B Penfigoide ampollar

C Necrólisis epidérmica tóxica

D Dermatitis herpetiforme

E Epidermólisis bullosa simple

Respuesta B. El cuadro clínico es patognomónico de Penfigoide Ampollar. Los hallazgos cardinales que lo confirman son: 1) Edad avanzada (76 años con patología neurológica crónica asociada); 2) Prurito intenso prodrómico; 3) Ampollas tensas, de paredes gruesas y resistentes que no se rompen fácilmente; 4) Signo de Nikolsky negativo (la epidermis sana no se desprende con la fricción); y 5) Ausencia de compromiso en la mucosa oral. El pénfigo vulgar (A) afectaría a personas más jóvenes (40-60 años), cursaría...

▶ VER CLASE 6.01.2.011 Quemadura solar

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.13 · Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Quemadura solar: quemadura superficial (eritema doloroso, grado I) o de espesor parcial superficial (ampollas, grado II) por radiación UVB, 6–24 horas después de la exposición; edema, dolor y prurito, luego descamación.
- Específico: diagnóstico clínico por antecedente de exposición y distribución en zonas expuestas; el eritema de grado I no se cuenta para superficie quemada. Buscar compromiso sistémico (fiebre, escalofríos, náuseas, hipotensión: golpe de sol, deshidratación).
- Tratamiento completo ambulatorio: compresas frías, hidratación oral, AINE o paracetamol para el dolor, emolientes, corticoide tópico de baja potencia en casos intensos, no romper las ampollas; no usar antibióticos profilácticos.
- Hospitalizar si hay superficie extensa con ampollas, compromiso sistémico, deshidratación o lactantes/niños pequeños.
- Seguimiento: no requiere control habitual; educar en evitar exposición (10–16 h), fotoprotección FPS ≥30 y barreras físicas; las quemaduras en la infancia aumentan el riesgo de melanoma.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 22 años consulta 12 horas después de pasar 6 horas en la playa sin fotoprotector. Tiene eritema intenso, doloroso y edema en espalda y hombros, con algunas ampollas pequeñas en los hombros. Está afebril, hidratada, sin compromiso del estado general. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Hospitalización y reanimación con fórmula de Parkland

B Compresas frías, hidratación oral, AINE para el dolor, emolientes, no romper las ampollas y fotoprotección estricta

C Corticoide sistémico en dosis altas

D Antibiótico oral profiláctico

E Aplicar pasta de dientes o mantequilla sobre la quemadura

Respuesta B. La quemadura solar es una quemadura superficial (eritema) o intermedia superficial (ampollas) por radiación UV. Sin compromiso sistémico se maneja ambulatoriamente con frío local, analgesia (AINE), hidratación, emolientes, cuidado de ampollas y evitar el sol. Se hospitaliza si es extensa con ampollas, hay deshidratación, fiebre o compromiso general, sobre todo en niños.

▶ VER CLASE 6.01.2.012 Sífilis congénita

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.4 · Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas

QUÉ HAY QUE SABER

- Sífilis congénita: transmisión transplacentaria de T. pallidum por madre con sífilis no tratada o mal tratada; prevención con tamizaje y tratamiento de la embarazada (GES sífilis en embarazo).
- Sospecha en el recién nacido: hepatoesplenomegalia, rinitis serosanguinolenta persistente (coriza), lesiones ampollares descamativas en palmas y plantas (pénfigo sifilítico), ictericia, anemia, lesiones óseas (osteocondritis), o asintomático con VDRL materno reactivo.
- Estudio inicial: VDRL en sangre del RN (título cuatro veces mayor que el materno es sugerente) y en LCR, hemograma, pruebas hepáticas, radiografía de huesos largos y fondo de ojo; el tratamiento no debe esperar.
- Tratamiento inicial: penicilina sódica EV por 10 días (50.000 UI/kg cada 12 horas la primera semana y cada 8 horas después); la penicilina benzatina no alcanza niveles en el sistema nervioso central.
- Seguimiento: derivar a neonatología/infectología; control con VDRL seriado hasta negativizar, evaluación neurológica y auditiva, y tratar a la madre y a sus contactos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de término, hijo de madre con VDRL reactivo 1:32 en el parto, sin control prenatal ni tratamiento. Al examen tiene hepatoesplenomegalia, rinitis serosanguinolenta persistente y lesiones ampollares descamativas en palmas y plantas. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Penicilina benzatina intramuscular dosis única

B Observación y VDRL a los 3 meses

C Ceftriaxona intramuscular por 3 días

D Azitromicina oral por 5 días

E Penicilina sódica endovenosa por 10 días, previo estudio con VDRL en sangre y LCR

Respuesta E. Un recién nacido con signos clínicos (hepatoesplenomegalia, coriza, pénfigo sifilítico palmoplantar) de madre con sífilis no tratada tiene sífilis congénita. Se estudia con VDRL en sangre y LCR, hemograma, radiografía de huesos largos y fondo de ojo, y se trata con penicilina sódica endovenosa por 10 días. La benzatina no alcanza niveles en el sistema nervioso central.

▶ VER CLASE 6.01.2.013 Síndrome de hipersensibilidad a drogas

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.10 · Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome de hipersensibilidad a drogas (DRESS): fármaco (anticonvulsivantes aromáticos, alopurinol, sulfas, dapsona, betalactámicos) con latencia larga de 2–8 semanas; reactivación de herpesvirus 6.
- Tríada: fiebre >38,5 °C, exantema morbiliforme confluente con edema facial periorbitario y adenopatías en ≥2 cadenas. Sin ampollas ni Nikolsky positivo. Eosinofilia y linfocitos atípicos; criterios RegiSCAR (≥4 puntos probable).
- El pronóstico lo define el órgano: hepatitis (75–90 %), nefritis tubulointersticial (sobre todo alopurinol), miocarditis (puede debutar semanas después) y neumonitis. Pedir hemograma, perfil hepático, creatinina y troponinas si hay síntomas.
- Tratamiento inicial: suspender el fármaco de inmediato y no reintroducir (reacción cruzada entre anticonvulsivantes aromáticos); hospitalizar si hay compromiso visceral; prednisona 0,5–1 mg/kg/día o metilprednisolona EV si hepatitis grave.
- Seguimiento completo: descenso muy lento de corticoides en 2–3 meses (bajar rápido provoca recaída fulminante) y control de función tiroidea a los 2 y 6 meses.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 94

Un paciente de 29 años, tratado con amoxicilina por amigdalitis pultácea diagnosticada hace 14 días, presenta desde hace 3 días ardor en los ojos, lesiones en la boca, malestar general y aparición de un rash cutáneo. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival bilateral, úlceras orales y un exantema con pápulas y placas eritematosas en tronco y extremidades. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Síndrome de Stevens-Johnson

B Gingivoestomatitis herpética

C Necrólisis epidérmica tóxica

D Pénfigo

E Escarlatina

Respuesta A. Compromiso de mucosas oral y ocular, exantema con pápulas y placas, y latencia de 14 días con un fármaco de riesgo como la amoxicilina: Síndrome de Stevens-Johnson. La gingivoestomatitis herpética no explica el compromiso ocular ni el exantema del tronco.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 48

Una paciente de 26 años, se realiza una colecistectomía laparoscópica hace 2 semanas. Inicialmente evoluciona bien, pero hace 12 horas presenta un cuadro de fiebre y dolor cutáneo generalizado, con eritema generalizado de la piel y compromiso de las mucosas. Hace algunas horas comienza con aparición de ampollas generalizadas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Psoriasis eritrodérmica

B Escarlatina quirúrgica

C Pustulosis exantemática

D Necrólisis epidérmica tóxica

E Pénfigo

Respuesta D. Latencia de 2 semanas tras una cirugía (con fármacos perioperatorios, típicamente betalactámicos), dolor cutáneo desproporcionado, eritema generalizado, compromiso de mucosas y ampollas generalizadas con desprendimiento: Necrólisis Epidérmica Tóxica.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años, con antecedente de crisis de gota, inició cotrimoxazol hace 12 días por una infección urinaria. Consulta por 3 días de fiebre de 38,8 °C, dolor faríngeo y ardor ocular, a lo que se agrega hoy una erupción dolorosa con máculas purpúricas de 2 anillos en tronco y algunas flictenas. Al examen presenta desprendimiento epidérmico estimado en 6% de la superficie corporal, úlceras orales con costras hemáticas y conjuntivitis bilateral. Al frotar suavemente la piel eritematosa perilesional, la epidermis se desprende con facilidad. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inmediata más adecuada?**

A Urticaria aguda; iniciar antihistamínico H1 de segunda generación

B Eritema multiforme major; observación ambulatoria con antivirales

C Síndrome de Stevens-Johnson; suspender el cotrimoxazol y hospitalizar

D Necrólisis epidérmica tóxica; traslado a Centro de Quemados

E Penfigoide ampollar; iniciar clobetasol tópico de alta potencia

Respuesta C. Latencia de 12 días con cotrimoxazol, pródromo pseudogripal, dianas atípicas de 2 anillos, Nikolsky positivo, desprendimiento del 6% de la BSA y compromiso de 2 mucosas: Síndrome de Stevens-Johnson. La conducta inmediata es suspender el fármaco y hospitalizar. NET requeriría más del 30%; el eritema multiforme no despega la piel; el penfigoide es Nikolsky negativo y en ancianos.

▶ VER CLASE 6.01.2.014 Síndrome de piel escaldada por estafilococos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.9 · Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome de piel escaldada por estafilococos (SSSS): toxina exfoliativa de S. aureus que causa despegamiento intraepidérmico superficial a distancia del foco; sobre todo en niños <5 años (conjuntivitis, impétigo, faringitis previos).
- Fiebre e irritabilidad, eritema doloroso difuso más intenso en pliegues y periorificial, costras radiadas alrededor de la boca, ampollas flácidas que dejan áreas denudadas; Nikolsky positivo; mucosas respetadas (clave frente a NET).
- Tratamiento inicial: hospitalizar y antibiótico antiestafilocócico endovenoso (cloxacilina o cefazolina; clindamicina si sospecha de SAMR), hidratación, analgesia, emolientes y control térmico. Corticoides contraindicados.
- Diferencial: NET/SSJ (adultos, fármacos, mucosas afectadas, biopsia con necrosis de toda la epidermis), impétigo ampolloso localizado, quemadura, pénfigo foliáceo.
- Seguimiento: no requiere; buen pronóstico en niños, cura sin cicatriz en 1–2 semanas. Buscar y tratar el foco infeccioso y contactos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 3 años con fiebre e irritabilidad de 2 días tras una conjuntivitis purulenta. Presenta eritema difuso, doloroso al tacto, más intenso en pliegues y periorificial, con costras radiadas alrededor de la boca y ampollas flácidas que se rompen dejando áreas denudadas. Nikolsky positivo. Las mucosas oral y conjuntival no tienen erosiones. **¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?**

A Síndrome de piel escaldada por estafilococo; hospitalización y cloxacilina (o cefazolina) endovenosa con soporte

B Necrólisis epidérmica tóxica; suspender fármacos e inmunoglobulina

C Impétigo ampollar localizado; mupirocina

D Escarlatina; amoxicilina oral

E Pénfigo vulgar; corticoides sistémicos

Respuesta A. En niños pequeños, una toxina exfoliativa del S. aureus produce despegamiento intraepidérmico superficial (granuloso) a distancia del foco: eritema doloroso, Nikolsky positivo y costras periorificiales, sin compromiso de mucosas. Se hospitaliza y trata con antiestafilocócico endovenoso y soporte (hidratación, analgesia). En la NET hay mucosas comprometidas y antecedente de fármaco.

▶ VER CLASE 6.01.2.015 Síndrome de Stevens-Johnson

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.9 · Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome de Stevens-Johnson: reacción adversa grave a fármacos (cotrimoxazol, alopurinol, carbamazepina/fenitoína, oxicams, aminopenicilinas) con latencia de 1–4 semanas; menos común por Mycoplasma o infecciones.
- Pródromo febril con ardor ocular y odinofagia; luego dianas atípicas de 2 anillos y ampollas con dolor cutáneo intenso, Nikolsky positivo, y erosiones hemorrágicas con costras en ≥2 mucosas (>90 %). Desprendimiento <10 % de la superficie (10–30 % superposición; >30 % NET).
- Diferenciar de eritema multiforme menor (dianas típicas de 3 anillos, sin despegamiento, mucosa mínima, gatillado por herpes) y de DRESS (latencia 2–8 semanas, edema facial, eosinofilia).
- Tratamiento inicial: suspender el fármaco sospechoso de inmediato, hospitalizar (UCI/quemados si progresa), hidratación, control térmico, curaciones atraumáticas, analgesia, evaluación oftalmológica urgente; calcular SCORTEN. No usar antihistamínicos como único manejo.
- Seguimiento: derivar a centro con unidad de quemados y dermatología; registrar la alergia al fármaco de por vida.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 76 años, con antecedente de enfermedad de Parkinson, consulta por 2 meses de prurito generalizado severo, al que se agregó en las últimas 2 semanas la aparición de múltiples ampollas de gran tamaño en el abdomen, las ingles y las caras internas de los muslos. Al examen se aprecian ampollas de contenido seroso claro, de paredes gruesas y muy tensas, sobre placas eritematosas. La mucosa oral no presenta lesiones. Al frotar con fuerza moderada la piel sana cercana, la epidermis no se despega. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Pénfigo vulgar

B Penfigoide ampollar

C Necrólisis epidérmica tóxica

D Dermatitis herpetiforme

E Epidermólisis bullosa simple

Respuesta B. Edad avanzada con patología neurológica de base, prurito intenso prodrómico, ampollas tensas y resistentes, Nikolsky negativo y mucosa oral respetada: Penfigoide Ampollar. El pénfigo afectaría a un paciente más joven, con ampollas flácidas, Nikolsky positivo y compromiso oral casi universal.

▶ VER CLASE 6.01.2.016 **Urticaria y angioedema** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.8 · Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Urticaria con o sin angioedema: habones evanescentes (<24 h) y/o edema profundo de labios, párpados, lengua. Aguda <6 semanas; crónica ≥6 semanas, mayormente espontánea y autoinmune (autoanticuerpos contra IgE/receptor del mastocito).
- Distinguir de vasculitis urticariana (habón fijo >24–48 h, doloroso, deja púrpura): biopsia cutánea. Anafilaxia si hay compromiso respiratorio, hemodinámico o digestivo: adrenalina IM de inmediato.
- Tratamiento completo sin anafilaxia: suspender desencadenante (AINE, alimento), antihistamínico H1 de segunda generación a dosis estándar (cetirizina, levocetirizina, desloratadina); corticoide oral solo ciclo ultracorto de rescate.
- Urticaria crónica: si no hay control en 2–4 semanas, cuadruplicar la dosis del mismo antihistamínico; luego omalizumab y ciclosporina (especialista). Nunca corticoides orales como mantenimiento.
- Seguimiento completo: controles hasta remisión, educar sobre signos de anafilaxia y evitar AINE; derivar urticaria crónica refractaria.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 30 años presenta, 1 hora después de tomar ibuprofeno, habones pruriginosos generalizados y edema de labios y párpados. No tiene disfonía, estridor, disnea, sibilancias, vómitos ni hipotensión. PA 120/75 mmHg, saturación 98%. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Adrenalina intramuscular y hospitalización en UCI

B Concentrado de inhibidor de C1 esterasa

C Intubación orotraqueal profiláctica

D Suspender el AINE, antihistamínico H1 de segunda generación y eventual curso corto de corticoide oral, con observación y educación sobre signos de anafilaxia

E Antibiótico oral

Respuesta D. Urticaria aguda con angioedema sin compromiso de vía aérea, respiratorio, digestivo ni hemodinámico no es anafilaxia: se suspende el desencadenante y se indican antihistamínicos H1 de segunda generación (pueden aumentarse hasta 4 veces la dosis), con corticoide oral breve si es extensa. La adrenalina IM se reserva para anafilaxia o angioedema laríngeo.

Conocimientos generales

3 códigos

▶ VER CLASE 6.01.3.001 **Fotoprotección**

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.14 · Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)

QUÉ HAY QUE SABER

- Principal medida de prevención primaria del cáncer de piel (basocelular, espinocelular y melanoma) y del fotoenvejecimiento; las quemaduras solares en la infancia aumentan el riesgo de melanoma y la dosis acumulada el de espinocelular. Chile tiene alta radiación UV (Índice UV extremo en verano).
- Evitar la exposición entre las 10 y 16 horas; barreras físicas: sombra, ropa de manga larga, sombrero de ala ancha y lentes con filtro UV; no usar camas solares (aumentan el riesgo de melanoma).
- Fotoprotector de amplio espectro (UVA y UVB) FPS ≥30, en cantidad suficiente, aplicado 15–30 minutos antes de la exposición y reaplicado cada 2–3 horas y tras el baño o sudor, incluso con nublado; mayor FPS en fototipos claros.
- Lactantes <6 meses: evitar exposición directa y priorizar sombra y ropa (sin filtros químicos como primera medida); niños: educación escolar sobre sol seguro.
- Poblaciones de mayor riesgo: fototipo claro, trabajadores al aire libre, trasplantados y pacientes con fotodermatosis, queratosis actínicas o antecedente de cáncer de piel; enseñar autoexamen mensual de nevos (ABCDE).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Madre consulta en control sano sobre medidas de fotoprotección para su hijo de 4 años y para ella, que tiene fototipo II. **¿Cuál es la recomendación más adecuada?**

A Usar fotoprotector solo los días soleados de verano

B Evitar la exposición entre las 10 y 16 horas, usar ropa, sombrero y lentes con filtro UV, y fotoprotector FPS 30 o más, reaplicado cada 2 a 3 horas y tras bañarse

C Aplicar fotoprotector una vez al día en la mañana es suficiente

D Las camas solares previas al verano protegen contra quemaduras

E En lactantes menores de 6 meses se recomienda fotoprotector químico abundante como primera medida

Respuesta B. La fotoprotección se basa en evitar el sol del mediodía, medidas físicas (sombra, ropa, sombrero, lentes) y fotoprotector de amplio espectro FPS 30 o más, aplicado 30 minutos antes y reaplicado cada 2 a 3 horas y tras el agua, incluso nublado. Las camas solares aumentan el riesgo de melanoma. Bajo 6 meses priman las medidas físicas.

▶ VER CLASE 6.01.3.002 Higiene de la vivienda y profilaxis del loxoscelismo

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.18 · Loxoscelismo (Loxosceles laeta): Cuadro Cutáneo y Cutáneo-Visceral, Manejo y Prevención en la Vivienda

QUÉ HAY QUE SABER

- Objetivo: reducir el contacto con Loxosceles laeta en el domicilio; la araña habita en rincones oscuros y secos, detrás de muebles, cuadros, ropa guardada y zapatos.
- Medidas de orden y aseo: despejar y limpiar periódicamente los rincones, aspirar y retirar telarañas, no acumular ropa, cajas ni papeles; sacudir ropa y zapatos antes de usarlos, sobre todo si estuvieron guardados.
- Cama y dormitorio: separar la cama de la pared, no dejar ropa de cama colgando hasta el suelo, revisar sábanas y toallas, y sellar grietas y espacios en muros y zócalos.
- Control químico solo con apoyo sanitario (desinsectación por empresas autorizadas); no manipular la araña con la mano, capturarla con un frasco para su identificación.
- Ante una picadura: consultar de inmediato, llevar la araña si es posible y no aplicar calor ni remedios caseros; educar a familias en zonas endémicas del país.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Familia de una zona rural consulta por haber encontrado arañas de rincón (Loxosceles laeta) en su casa. Preguntan cómo prevenir mordeduras. **¿Cuál es la medida de prevención más adecuada?**

A Mantener la casa a oscuras y cerrada

B Usar insecticida una vez al año como única medida

C Aseo frecuente detrás de muebles y cuadros, separar camas de la pared, sacudir ropa, zapatos y toallas antes de usarlas, y evitar acumular objetos

D Dormir con la ropa del día

E Eliminar a las arañas tigre (Scytodes), que son sus predadoras

Respuesta C. La araña de rincón es nocturna y vive en lugares oscuros y tranquilos (detrás de cuadros, muebles, ropa guardada); la mayoría de las mordeduras ocurren al vestirse o en la cama. Se previene con aseo frecuente moviendo muebles, camas separadas de la pared y sacudir ropa y calzado. La araña tigre es su predador natural.

▶ VER CLASE 6.01.3.003 Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.1 · Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel

QUÉ HAY QUE SABER

- La piel refleja enfermedades sistémicas y puede ser la primera pista diagnóstica: el médico general debe reconocer los signos cutáneos y pedir el estudio adecuado.
- Diabetes: acantosis nigricans (resistencia a insulina, obesidad), necrobiosis lipoídica, candidiasis, infecciones y pie diabético. Tiroides: mixedema pretibial (Graves), vitíligo, piel seca (hipotiroidismo). Enfermedad celíaca: dermatitis herpetiforme. Autoinmune: eritema malar y fotosensibilidad (LES), heliotropo y pápulas de Gottron (dermatomiositis), esclerodactilia (esclerodermia).
- Infecciones/neoplasias: sífilis secundaria (exantema palmoplantar), VIH (dermatitis seborreica severa, sarcoma de Kaposi), eritema nodoso (estreptococo, TBC, sarcoidosis, EII), pioderma gangrenoso (EII, artritis), prurito generalizado (colestasis, uremia, linfoma), signo de Leser-Trélat.
- Hígado y riñón: ictericia, arañas vasculares y eritema palmar (cirrosis), púrpura; xerosis y prurito urémico. Hematología: palidez y petequias.
- Conducta: ante lesión cutánea sugerente, dirigir anamnesis y estudio de la enfermedad de base (glicemia, TSH, ANA, VDRL, VIH, función hepática y renal) y derivar a la especialidad correspondiente.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una paciente de 25 años consulta por una erupción cutánea diseminada. El médico describe lesiones circunscritas de contenido líquido claro seroso, de 2 a 3 milímetros de diámetro, agrupadas en racimo sobre una base eritematosa en el labio superior. **¿Cuál es el nombre semiológico exacto de esta lesión elemental primaria?**

A Pústula
B Vesícula
C Ampolla
D Pápula
E Erosión

Respuesta B. Colección circunscrita de líquido seroso en la epidermis, con diámetro menor a 0,5 cm: vesícula. La ampolla es mayor a 0,5–1 cm; la pústula tiene contenido purulento desde su origen; la pápula es sólida; la erosión es una lesión secundaria por pérdida de sustancia.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 32 años consulta por lesiones pruriginosas en los codos. Al examen físico se aprecian lesiones sobreelevadas sólidas eritematosas que miden entre 3 y 5 cm de diámetro, con superficie aplanada en meseta y cubiertas por abundantes escamas plateadas que confluyen formando áreas extensas. **¿Cuál es el nombre semiológico correcto de esta lesión elemental?**

A Mancha
B Pápula
C Placa
D Nódulo
E Habón

Respuesta C. Elevación sólida circunscrita, con diámetro mayor a 1 cm y extensión en superficie que supera su altura (en meseta), formada por confluencia de lesiones más pequeñas: placa. La descamación plateada sobre una placa en superficies de extensión es la lesión elemental clásica de la psoriasis vulgar.

Exámenes e imagenología

7 códigos

▶ VER CLASE 6.01.4.001 **Acarotest** NIVEL REALIZA, INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.16 · Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Acarotest: examen para confirmar escabiosis; se busca un surco acariano o pápula no excoriada en espacios interdigitales, muñecas o genitales.
- Técnica: aplicar una gota de aceite mineral o KOH, raspar el surco con hoja de bisturí o cureta hasta eliminar el techo y observar al microscopio el ácaro (Sarcoptes scabiei), huevos o escíbalos.
- Indicación: prurito nocturno intenso con convivientes afectados, lesiones en pliegues interdigitales, muñecas, ombligo y genitales, o sospecha en lactantes y ancianos (sarna costrosa).
- Alta especificidad pero sensibilidad limitada: un acarotest negativo no excluye escabiosis; se trata igual si la clínica es compatible.
- El médico general realiza, interpreta y emplea el resultado: positivo confirma y justifica tratamiento simultáneo de todos los contactos con permetrina 5 %.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 35 años con prurito intenso de predominio nocturno de 3 semanas. Su pareja tiene síntomas similares. Al examen se observan pápulas excoriadas en espacios interdigitales, muñecas, ombligo y genitales, y algunos surcos lineales finos. **¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico?**

A Micológico directo con KOH
B Test de Tzanck
C Biopsia de piel con inmunofluorescencia
D IgE total
E Acarotest: raspado de un surco con observación microscópica del ácaro, huevos o deyecciones

Respuesta E. Prurito nocturno, convivientes afectados, distribución en pliegues interdigitales, muñecas, ombligo y genitales y surcos acarinos sugieren escabiosis. El acarotest (raspado del surco y microscopía) confirma al observar Sarcoptes scabiei, huevos o fecas; tiene alta especificidad pero sensibilidad limitada, por lo que un resultado negativo no descarta y se trata ante clínica sugerente.

▶ VER CLASE 6.01.4.002 **Dermatoscopía** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.13 · Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Dermatoscopía: examen no invasivo con lente de aumento y luz polarizada o líquido de inmersión que permite ver estructuras pigmentarias invisibles a simple vista; el médico general emplea el informe del especialista.

- Indicaciones: evaluación de lesiones melanocíticas sospechosas (ABCDE, nevo cambiante, «patito feo»), seguimiento de pacientes con múltiples nevos o antecedente familiar, y apoyo en queratosis seborreica, carcinoma basocelular y lesiones vasculares.
- Hallazgos sugerentes de melanoma: retículo pigmentado atípico, velo azul-blanquecino, puntos y glóbulos irregulares, estrías irregulares, regresión; basocelular: vasos arboriformes y glóbulos azul-grisáceos.
- Mejora la sensibilidad y especificidad del examen clínico y orienta qué lesiones biopsiar, pero no reemplaza a la biopsia: el diagnóstico definitivo y el Breslow los entrega la histología.
- Lesión con alta sospecha clínica se biopsia (excisional) sin esperar la dermatoscopía; el informe se usa para decidir derivación, seguimiento digital o extirpación.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 40 años con múltiples nevos consulta por un nevo en la espalda que su pareja nota diferente a los demás. Mide 7 mm, es asimétrico, de bordes irregulares y con 2 tonos de marrón. **¿Cuál es la principal utilidad de la dermatoscopía en este caso?**

A Aumenta la sensibilidad y especificidad del examen clínico para identificar lesiones sospechosas de melanoma y decidir cuáles biopsiar

B Reemplaza a la biopsia como diagnóstico definitivo de melanoma

C Mide la profundidad de Breslow

D Detecta metástasis ganglionares

E Solo sirve para diagnosticar micosis

Respuesta A. La dermatoscopía es un examen no invasivo con aumento y luz polarizada que permite ver estructuras pigmentarias no visibles a simple vista (retículo atípico, velo azul-blanquecino, puntos irregulares). Mejora la precisión diagnóstica del melanoma respecto al ojo desnudo y orienta qué lesiones extirpar; el diagnóstico definitivo y el Breslow los da la histología.

▶ VER CLASE 6.01.4.003 Gram y cultivo

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.1 · Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Gram y cultivo de secreción (piel y partes blandas): se toma pus de un absceso drenado, exudado de herida o ampolla, antes de iniciar el antibiótico, con técnica estéril.
- Indicaciones: abscesos o piodermias recurrentes, extensas o con compromiso sistémico, inmunosuprimidos, falla de tratamiento, sospecha de SAMR comunitario, infección de herida quirúrgica y celulitis con colección. No es necesario en impétigo o celulitis simple.
- Gram: cocos grampositivos en racimos sugieren S. aureus; en cadenas, S. pyogenes; bacilos gramnegativos orientan a Pseudomonas o enterobacterias (pie diabético, tinas calientes).
- Cultivo con antibiograma identifica el agente y su susceptibilidad, incluida la resistencia a meticilina (SAMR) y a clindamicina, y permite dirigir el tratamiento.
- Interpretar y emplear: ajustar antibiótico al resultado (SAMR: cotrimoxazol, clindamicina o vancomicina), no tratar colonización y derivar infecciones graves o de mala evolución.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años con un absceso de 4 cm en el muslo, fluctuante, recurrente por tercera vez en el año. Su pareja tuvo forúnculos recientemente. Se drena en urgencia. **¿Qué examen debe solicitarse de la secreción obtenida y por qué?**

A Ninguno, el drenaje es suficiente en todos los casos

B Gram y cultivo con antibiograma, para identificar S. aureus y su susceptibilidad (incluida resistencia a meticilina) por la recurrencia

C Baciloscopía

D PCR para virus herpes

E Micológico directo

Respuesta B. En abscesos y piodermias recurrentes, extensos, con compromiso sistémico, en inmunosuprimidos o con falla de tratamiento, el Gram y el cultivo con antibiograma de la secreción identifican al agente (habitualmente S. aureus) y su susceptibilidad, incluida la resistencia a meticilina comunitaria, lo que orienta el antibiótico y la descolonización.

▶ VER CLASE 6.01.4.004 Micológico directo de piel, pelos y uñas

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.16 · Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Micológico directo (KOH): examen de primera línea para tiñas, pitiriasis versicolor, candidiasis y onicomicosis; se complementa con cultivo micológico que identifica el agente.
- Técnica: raspar escamas del borde activo de la lesión (donde están las hifas), pelos rotos (tiña capitis) o detritus subungueal; digerir con KOH 10–20 % y observar al microscopio. Suspender antifúngicos 1–2 semanas antes para evitar falsos negativos.
- Hallazgos: dermatofitos con hifas tabicadas y ramificadas; pitiriasis versicolor con esporas redondas e hifas cortas («albóndigas con espaguetis»); Candida con pseudohifas y levaduras en gemación.
- Muchas distrofias ungueales no son micóticas (psoriasis, liquen, trauma): confirmar con KOH y cultivo antes de usar terbinafina oral 12 semanas.
- Interpretar y emplear: positivo respalda el antifúngico (tópico u oral según localización); si es negativo con alta sospecha, repetir o cultivar.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 35 años consulta por una placa anular de 4 cm en el tronco, pruriginosa, con borde eritematoso descamativo activo y centro más claro, de 3 semanas de evolución. No ha usado ningún tratamiento. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A Examen micológico directo con hidróxido de potasio y cultivo de escamas obtenidas del borde activo

B Biopsia de piel del centro de la lesión

C Prueba del parche

D Inmunoglobulina E sérica

E Cultivo bacteriano de la lesión

Respuesta A. La sospecha es una tiña corporis. Se confirma con micológico directo: se raspan escamas del borde activo, donde están las hifas, y se observan con hidróxido de potasio, complementado con cultivo para identificar la especie. Si el paciente ya usó antifúngicos, conviene suspenderlos 1 a 2 semanas antes para evitar falsos negativos.

▶ VER CLASE 6.01.4.005 Patch test

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.7 · Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

QUÉ HAY QUE SABER

- Patch test (pruebas epicutáneas): examen de confirmación de dermatitis de contacto alérgica (hipersensibilidad tipo IV); los alérgenos se aplican en parches en la espalda.
- Se leen a las 48 horas (al retirar parches) y a las 96 horas: la reacción alérgica persiste o aumenta; la irritativa se desvanece.
- Indicar ante eccema crónico de manos o de localización sugerente, sospecha de alérgeno ocupacional o dermatitis sin causa evidente. Alérgenos frecuentes: níquel, dicromato de potasio, fragancias, conservantes, caucho.
- Debe realizarse con la dermatitis en remisión y sin corticoides sistémicos ni tópicos potentes en la zona; no se indica en dermatitis seborreica ni atópica.
- Interpretar positivo como sensibilización con relevancia clínica solo si coincide con la exposición; en la irritativa es negativo. Emplear el resultado para educar en evitar el alérgeno.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 26 años consulta por lesiones eccematosas muy pruriginosas en el abdomen inferior de 3 semanas de evolución. Al examen se aprecia una placa eritematosa con pequeñas vesículas y excoriaciones por rascado, localizada en la línea media periumbilical inferior, que coincide exactamente con el roce de la hebilla metálica de sus pantalones de mezclilla. Además, refiere que cuando usa aretes de fantasía se le inflaman los lóbulos de las orejas. **¿Cuál es la conducta diagnóstica de confirmación?**

A Biopsia cutánea urgente

B Pruebas epicutáneas del parche con lectura a 48 y 96 horas

C Cultivo de secreción cutánea

D Examen directo con hidróxido de potasio

E Determinación de inmunoglobulina E sérica total

Respuesta B. Placa pruriginosa que sobrepasa la zona de contacto con una hebilla metálica, más el antecedente de reacción a bisutería: dermatitis de contacto alérgica por níquel. La confirmación etiológica es la prueba epicutánea del parche con lectura a las 48 y 96 horas.

▶ VER CLASE 6.01.4.006 Test TZANCK

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.12 · Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple

QUÉ HAY QUE SABER

- Test de Tzanck: raspado de la base de una vesícula reciente (desbridar el techo), extendido y tinción de Giemsa o Wright para observar queratinocitos acantolíticos y células gigantes multinucleadas.
- Indicación: lesiones vesiculares sospechosas de herpes simple, varicela o herpes zóster; también muestra células acantolíticas en el pénfigo vulgar.
- Limitación: no distingue herpes simple de varicela-zóster y su sensibilidad es moderada (alrededor de 60–70 %); un resultado negativo no descarta infección.
- Es rápido, barato y se hace a la cabecera; hoy la PCR viral en la lesión es el examen de elección cuando está disponible (también permite tipificar).
- Interpretar según contexto: células gigantes multinucleadas en cuadro vesicular agrupado confirman infección herpética; usar el resultado para decidir aciclovir y derivación en inmunosuprimidos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 25 años con vesículas agrupadas sobre base eritematosa en el labio superior, precedidas de ardor. Se realiza raspado de la base de una vesícula reciente con tinción de Giemsa (test de Tzanck). **¿Qué hallazgo se espera y cuál es su principal limitación?**

A Células gigantes multinucleadas; no distingue entre virus herpes simple y varicela-zóster

B Hifas tabicadas; no distingue dermatofitos

C Cocos gram positivos en racimos; no distingue S. aureus de S. epidermidis

D Ácaros; baja sensibilidad

E Células de Sézary; requiere citometría

Respuesta A. El test de Tzanck muestra queratinocitos acantolíticos y células gigantes multinucleadas en lesiones por herpes simple y varicela-zóster, pero no diferencia entre ellos y tiene sensibilidad moderada. La PCR viral es hoy el examen de elección. También muestra células acantolíticas en el pénfigo vulgar.

▶ VER CLASE 6.01.4.007 VDRL - MHATP

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA

Infectología 3.4 · Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) I: Sífilis en Todas sus Etapas

QUÉ HAY QUE SABER

- VDRL (no treponémica, cuantitativa) y MHA-TP (treponémica, cualitativa): se interpretan en conjunto para el diagnóstico de sífilis.
- VDRL reactivo + MHA-TP reactivo = sífilis activa: tratar según tiempo de evolución (benzatina 2,4 millones UI IM, 1 dosis si precoz, 3 si tardía o desconocida). VDRL reactivo en título bajo + treponémica no reactiva = falso positivo biológico (LES, embarazo, infecciones virales, edad): no tratar.
- VDRL no reactivo + MHA-TP reactivo = cicatriz serológica de sífilis tratada (o primaria muy precoz): si fue tratada, no tratar; en el embarazo seguir el control con VDRL a las 28–30 semanas. Ambos no reactivos con chancro: período de ventana, repetir en 3 semanas.
- Seguimiento postratamiento solo con VDRL cuantitativo (curación = descenso de 4 veces o 2 diluciones a los 6–12 meses); las treponémicas permanecen positivas de por vida y no sirven para reinfección. En embarazadas con sífilis previa, un VDRL reactivo exige tratar de inmediato.
- Emplear e interpretar: en toda embarazada, ITS o pareja de caso; notificar casos confirmados y estudiar VIH.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Embarazada de 12 semanas en su primer control. VDRL reactivo 1:2. Se solicita MHA-TP, que resulta no reactivo. No tiene lesiones ni antecedentes de sífilis. Tiene diagnóstico reciente de lupus eritematoso sistémico. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Sífilis latente precoz; penicilina benzatina

B Sífilis primaria en período de ventana

C Sífilis tratada previamente (cicatriz serológica)

D Falso positivo biológico del VDRL, probablemente asociado al lupus

E Neurosífilis

Respuesta D. El VDRL es una prueba no treponémica, sensible y útil para seguimiento, pero con falsos positivos (habitualmente títulos bajos) en LES, síndrome antifosfolípido, embarazo, infecciones virales y otras. Las pruebas treponémicas (MHA-TP, FTA-Abs) confirman y quedan positivas de por vida. VDRL reactivo con treponémica negativa es un falso positivo biológico.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

1 códigos

▶ VER CLASE 6.01.5.001 Biopsia de piel

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA

Dermatología 16.11 · Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)
Dermatología 16.13 · Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Biopsia de piel: procedimiento que se deriva a especialista; el médico general conoce indicaciones y el tipo de muestra requerida.
- Indicaciones: sospecha de melanoma o lesión pigmentada cambiante, cáncer de piel no melanoma, dermatosis ampollares (pénfigo y penfigoide), vasculitis, lupus cutáneo, linfoma cutáneo, y lesiones crónicas que no responden al tratamiento.
- Melanoma: biopsia excisional completa con margen de 1–2 mm hasta la hipodermis; shave o punch superficial contraindicados. Ampollares: ampolla reciente (histología) + piel perilesional sana para inmunofluorescencia directa; no biopsiar erosiones antiguas.
- Antes de derivar: indicar al paciente que mantenga la lesión sin manipular, registrar localización y tamaño, y evaluar anticoagulantes, alergia a anestésicos y cicatrización queloidea.
- Derivar a dermatología o cirugía con pedido de histología (y de inmunofluorescencia si corresponde); ante sospecha de melanoma, derivar con carácter preferente.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 46 años consulta por un nevo en la espalda que ha cambiado de color y aumentado de tamaño en los últimos 4 meses. Al examen se observa una lesión macular asimétrica de 8 mm con bordes irregulares y tres colores distintos (café claro, negro y grisáceo). **¿Cuál es la conducta diagnóstica de elección?**

A Cauterización con nitrógeno líquido (crioterapia) en la consulta

B Biopsia excisional completa con 1 a 2 mm de margen lateral y celular subcutáneo

C Biopsia por afeitado (shave) superficial para no dejar cicatriz antiestética

D Biopsia por sacabocados (punch) de 2 mm tomada del centro más pigmentado de la lesión

E Control fotográfico digital seriado cada 3 meses

Respuesta B. Ante una lesión con sospecha clínica de melanoma maligno, el estándar de oro diagnóstico es la biopsia excisional completa con márgenes estrechos de 1 a 2 mm y en toda la profundidad del tejido celular subcutáneo, lo que permite medir el espesor de Breslow sin desestructurar la lesión.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 72 años presenta hace 3 semanas ampollas tensas de contenido seroso sobre placas eritematosas en el abdomen y las caras internas de los muslos, con prurito intenso y sin compromiso de mucosas. Se sospecha una enfermedad ampollar autoinmune. **¿Cuál es el estudio más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A Cultivo del contenido de la ampolla

B Biopsia de una ampolla reciente para histología y biopsia de piel perilesional para inmunofluorescencia directa

C Test de Tzanck

D Biopsia del centro de una erosión antigua

E Examen micológico directo

Respuesta B. En enfermedades ampollares autoinmunes se toman dos muestras: una ampolla reciente e intacta para histología, que muestra el nivel de separación, y piel perilesional sana para inmunofluorescencia directa, que muestra el depósito de anticuerpos. Las erosiones antiguas no sirven porque el tejido está destruido.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años consulta por una lesión pigmentada en la pantorrilla izquierda, de 5 meses de evolución, con crecimiento progresivo y prurito ocasional. Al examen se observa una mácula de 8 mm de diámetro mayor, asimétrica, de bordes irregulares, con tonalidades café oscuro, negro y un área grisácea central. No se palpan adenopatías inguinales. **¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?**

A Biopsia excisional completa con 1 a 2 mm de margen y tejido celular subcutáneo

B Biopsia por sacabocados (punch) del área más pigmentada

C Crioterapia con nitrógeno líquido en la misma consulta

D Control fotográfico digital seriado en 6 meses

E Biopsia por afeitado (shave) superficial

Respuesta A. La lesión cumple los cinco criterios del ABCDE: asimetría, bordes irregulares, color heterogéneo, diámetro mayor a 6 mm y evolución en 5 meses. Ante esa sospecha, la conducta obligatoria es la biopsia excisional completa con margen estrecho e hipodermis, que permite medir el Breslow real. El punch y el shave subestiman el espesor; la crioterapia y el control diferido retrasan el diagnóstico de un posible cáncer.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 114

Adulto mayor con Alzheimer presenta lesiones ulceradas en la pierna de aspecto sospechoso. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Iniciar antibiótico tópico y cubrir

B Curación avanzada con alginato de calcio

C Solicitar Doppler venoso de extremidades

D Tomar biopsia de las lesiones

E Derivar a dermatología en control habitual

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Tomar biopsia de las lesiones (opción D). Tomar biopsia de las lesiones.

17

OFTALMOLOGÍA

63 CÓDIGOS

119 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	31
Situaciones clínicas de urgencia	10
Conocimientos generales	6
Exámenes e imagenología	2
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	14

Situaciones clínicas

31 códigos

▶ VER CLASE **6.02.1.001** **Ametropía** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.9 · Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Ametropías: miopía (ojo largo, foco delante de la retina; mala visión de lejos y buena de cerca; lentes divergentes negativos), hipermetropía (ojo corto, foco detrás; astenopia acomodativa con cefalea frontal; lentes convergentes positivos; predispone a glaucoma agudo) y astigmatismo (córnea irregular, visión distorsionada de lejos y cerca; lentes cilíndricos).
- Sospecha: baja de agudeza visual, entrecerrar los ojos, acercarse a la pantalla o al libro, cefalea y fatiga ocular. La clave diagnóstica es el agujero estenopeico (1–1,5 mm): si la AV mejora es un vicio de refracción; si no mejora hay lesión orgánica (catarata, maculopatía, neuritis) o ambliopía.
- Presbicia: pérdida fisiológica de acomodación desde los 40–45 años (síndrome de los brazos cortos); se corrige con lentes positivos para cerca.
- Tratamiento inicial en APS: confirmar con tabla de Snellen y estenopeico, descartar causas orgánicas, y entregar o indicar corrección óptica según la prescripción; en niños, pesquisar ambliopía.
- Seguimiento: derivar a oftalmología/optometría para refracción y receta de lentes; control anual en niños (la miopía alta predispone a desprendimiento de retina y glaucoma crónico).

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 125

Un paciente de 18 años presenta agudeza visual de 1 en el ojo izquierdo y de 0,6 en el ojo derecho, que mejora a 0,8 al mirar por un agujero estenopeico. No presenta dolor. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Glaucoma
B Estrabismo
C Vicio de refracción
D Catarata
E Coriorretinitis

Respuesta C. La mejoría de la agudeza visual al mirar por un agujero estenopeico es característica de los vicios de refracción: el defecto es puramente óptico, no orgánico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 95

Un niño de 5 años, nacido a las 32 semanas por parto vaginal, es llevado a control porque se acerca mucho a la pantalla cuando ve televisión. La inspección ocular es normal. La agudeza visual es 20/25 en el ojo derecho y 20/80 en el ojo izquierdo, la cual mejora a 20/25 al usar un agujero estenopeico. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Ambliopía
B Microftalmia
C Ametropía
D Glaucoma congénito
E Retinopatía del prematuro

Respuesta C. La mejora de la agudeza visual al mirar a través de un agujero estenopeico es característica de los vicios de refracción, o ametropías. Aquí la agudeza visual se corrige por completo, así que no hay ambliopía; si solo hubiese mejorado en forma parcial, el diagnóstico habría incluido ambliopía anisometrópica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 40

Un niño de 6 años consulta por dificultades para ver. Al examen físico destaca agudeza visual de 20/60, que cambia a 20/30, al mirar por un agujero estenopeico. La madre refiere que siempre se restriega los ojos. El diagnóstico más probable es:

A Blefaritis
B Conjuntivitis viral
C Ametropía
D Conjuntivitis bacteriana crónica
E Glaucoma congénito

Respuesta C. Tiene una caída de la AV que mejora al mirar por un agujero estenopeico, así que tiene un vicio de refracción, también llamado ametropía. La AV pasó de 0,33 a 0,67, por lo que mejoró (se calcula con la simple división de 20/60 y 20/30).

▶ VER CLASE **6.02.1.002** **Blefaritis** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.3 · Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Blefaritis: inflamación crónica y bilateral del borde palpebral, asociada a dermatitis seborreica y rosácea; ardor, arenilla, prurito y costras al despertar. Anterior: escamas grasosas (seborreica) o collaretes duros (estafilocócica) en la base de las pestañas. Posterior: disfunción de glándulas de Meibomio con secreción espesa tipo «pasta de dientes» y ojo seco.

- Específico: diagnóstico clínico por inspección del borde con lupa; descartar chalazión recurrente, ojo seco y carcinoma sebáceo en cuadros unilaterales o asimétricos con pérdida de pestañas.
- Tratamiento completo: higiene palpebral diaria (compresas tibias previas y limpieza con champú de bebé neutro diluido o toallitas específicas), masaje del borde y lágrimas artificiales; es el pilar y va antes de cualquier colirio.
- Casos moderados o con rosácea: ungüento antibiótico (eritromicina o cloranfenicol) en el borde y doxiciclina oral 100 mg/día por 4–6 semanas. Corticoide tópico solo con indicación oftalmológica.
- Seguimiento completo: es crónica y recidivante, se controlan las recaídas; derivar si hay compromiso corneal, baja de visión o falta de respuesta.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 60 años, con rosácea, consulta por ardor y sensación de cuerpo extraño en ambos ojos de varios meses, peor al despertar. Al examen hay bordes palpebrales eritematosos y engrosados, con escamas adheridas a la base de las pestañas y orificios de las glándulas de Meibomio obstruidos. Agudeza visual normal. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A Antibiótico oral por 7 días y alta

B Drenaje quirúrgico de las glándulas de Meibomio

C Colirio de corticoide de alta potencia en forma permanente

D Derivación urgente a oftalmología

E Higiene palpebral diaria con compresas tibias y masaje del borde palpebral, más lágrimas artificiales

Respuesta E. La blefaritis es una inflamación crónica del borde palpebral, asociada a dermatitis seborreica y rosácea. La base del tratamiento es la higiene palpebral diaria: compresas tibias, masaje y limpieza del borde, con lágrimas artificiales. En casos persistentes se agregan antibióticos tópicos, o doxiciclina oral en la disfunción de Meibomio.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 163

Una niña de 12 años consulta por molestias, secreción y una lesión en el ojo iz- quierdo, que se muestra en la siguiente foto: INSERTAR FOTO ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A Amoxicilina

B Azitromicina

C Aciclovir

D Mupirocina

E Dexametasona

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Aciclovir (opción C). Era un herpes periocular. La queratitis herpética produce una úlcera dendrítica o en helecho, prácticamente patognomónica de herpes simple ocular, tratamiento con aciclovir tópico y oral.

▶ VER CLASE 6.02.1.003 Catarata

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.8 · Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación

QUÉ HAY QUE SABER

- Catarata: opacificación del cristalino; senil en >90 % (nuclear: esclerosis amarillenta y miopización; cortical: opacidades en radios de rueda; subcapsular posterior: caída rápida y deslumbramiento diurno). Secundarias: corticoides (subcapsular posterior, incluso en jóvenes), diabetes, trauma (roseta), uveítis, congénita.
- Específico: baja de visión lenta, bilateral, indolora y sin ojo rojo; deslumbramiento al conducir de noche; «segunda visión» (el présbita vuelve a leer sin lentes). Confirmar con reflejo rojo pupilar con oftalmoscopio directo a 1 metro (atenuado o con manchas oscuras); una AV que no mejora con agujero estenopeico sugiere opacidad de medios.
- No existe tratamiento médico: ningún colirio previene ni revierte la catarata. En leucocoria en un niño descartar retinoblastoma y catarata congénita (derivación urgente).
- Tratamiento inicial: notificar GES catarata (nº 21; ojo con AV ≤0,3) y derivar para cirugía, que se indica por el impacto funcional (leer, conducir, riesgo de caídas) y no por «madurez»; técnica de elección facoemulsificación con lente intraocular, ambulatoria.
- Seguimiento: derivar a oftalmología; corregir vicios de refracción mientras tanto y control de diabetes; evitar corticoides prolongados.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 171

Una paciente de 78 años presenta disminución de la visión del ojo derecho, de 4 meses de evolución. Al examen tiene caída de la agudeza visual de dicho ojo, con disminución de la visión del contraste y afectación del rojo pupilar. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Glaucoma crónico

B Catarata

C Degeneración macular relacionada con la edad

D Vicio de refracción

E Atrofia del nervio óptico

Respuesta B. Baja visual progresiva, con disminución de la sensibilidad al contraste y alteración del reflejo rojo pupilar: catarata. El glaucoma no altera el reflejo rojo ni la agudeza visual central hasta el final; el vicio de refracción no afecta el rojo pupilar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 33

Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, consulta por disminución progresiva de la agudeza visual del ojo derecho. Tiene agudeza visual 20/20 en el ojo izquierdo y bastante menor en el derecho. Su rojo pupilar demuestra una opacidad central con forma de estrella. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Retinopatía diabética
B Edema macular
C Catarata
D Glaucoma
E Hemorragia vítrea

Respuesta C. Disminución progresiva de la agudeza visual con opacidad central en el rojo pupilar: catarata. La retinopatía diabética no da síntomas directos; el edema macular progresa en días, no de forma lenta; el glaucoma no afecta el rojo pupilar; la hemorragia vítrea es de aparición súbita.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 156

Paciente con agudeza visual 20/40 bilateral que no mejora con agujero estenopeico. La refracción no muestra cambios. **¿Cuál es la causa más probable de esta alteración visual?**

A Opacidad de medios, como una catarata
B Error refractivo no corregido
C Ambliopía
D Glaucoma
E Degeneración macular

Respuesta A. El agujero estenopeico mejora la visión solo cuando la causa es un error refractivo. Si no mejora y la refracción es normal, la causa es una opacidad de medios, como la catarata, o una patología retinal o neural; en un adulto mayor, lo más probable es catarata.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 72 años, autovalente, consulta por visión borrosa bilateral de 1 año de evolución que le dificulta reconocer caras en la calle. De noche le molestan mucho las luces de los autos, pero comenta contenta que ahora puede leer el diario sin sus lentes de aumento. No refiere dolor ni ojo rojo. Agudeza visual 20/70 en ambos ojos. La oftalmoscopía muestra atenuación marcada del reflejo rojo pupilar bilateral. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar un colirio antioxidante para retrasar la progresión
B Tranquilizar: leer sin lentes es un signo de mejoría
C Notificar GES 21 y derivar para facoemulsificación con lente intraocular
D Solicitar campo visual computarizado antes de decidir
E Indicar cambio de lentes ópticos y control en 1 año

Respuesta C. Baja visual lenta, bilateral e indolora, con deslumbramiento nocturno, miopización paradójica y atenuación del reflejo rojo pupilar: catarata senil. La conducta es notificar la garantía GES 21 y derivar para facoemulsificación con implante de lente intraocular; no existe tratamiento médico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 31

Lactante de 7 meses cuya madre nota que al iluminar sus ojos con linterna, el ojo derecho refleja luz blanca (leucocoria) en vez del habitual reflejo rojo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Descartar toxoplasmosis ocular: solicitar serología
B Catarata congénita: derivar urgente a oftalmología
C Retinoblastoma: derivar urgente a oftalmología
D Retinopatía del prematuro: si no fue prematuro, tranquilizar
E Glaucoma congénito: iniciar colirio

Respuesta B. Leucocoria (reflejo pupilar blanco) en lactante: principal diagnóstico a descartar es CATARATA CONGÉNITA y retinoblastoma. A los 7 meses sin antecedente de prematuridad, catarata congénita es lo más frecuente. Derivación urgente a oftalmología para tratamiento precoz (cirugía antes de los 10 semanas para evitar ambliopía).

▶ VER CLASE 6.02.1.004 Chalazion

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.3 · Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Chalazión: granuloma lipídico por obstrucción de una glándula de Meibomio, sin infección activa; nódulo firme, redondeado, indoloro, en el espesor del párpado, con piel móvil, de semanas de evolución (a menudo tras un orzuelo mal resuelto).
- Específico: diagnóstico clínico; evertir el párpado para ver el lado conjuntival. Sospechar carcinoma sebáceo o basocelular si es recidivante en el mismo sitio, en adulto mayor, con pérdida de pestañas o ulceración (biopsia).
- Tratamiento inicial: compresas tibias y masaje del párpado 3–4 veces al día por varias semanas; muchos resuelven espontáneamente.
- Si persiste más de 2 meses, es muy grande o comprime la córnea y produce astigmatismo: curetaje quirúrgico o infiltración de triamcinolona intralesional por oftalmología.
- Seguimiento: derivar a oftalmología si persiste, recidiva o es atípico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 42 años consulta por la aparición de un nódulo firme en el párpado superior derecho de 6 semanas de evolución. Refiere que hace dos meses tuvo un cuadro inflamatorio doloroso que se resolvió solo, quedando esta lesión que no le duele en absoluto. Al examen se palpa un nódulo subcutáneo redondeado de 5 milímetros en el espesor del tarso superior, no adherido a la piel y completamente indoloro a la palpación. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Orzuelo interno agudo

B Chalazión

C Carcinoma sebáceo de párpado

D Dacriocistitis crónica

E Quiste de inclusión epidérmica

Respuesta B. Nódulo firme, bien delimitado, indoloro y de varias semanas de duración, que sucede a un episodio agudo previo mal resuelto, es la presentación clásica del chalazión: un granuloma por retención lipídica tras la obstrucción de una glándula de Meibomio. El orzuelo agudo duele; el carcinoma sebáceo se sospecha solo si el chalazión recidiva en un anciano con pérdida de pestañas.

▶ VER CLASE 6.02.1.005 Conjuntivitis bacteriana aguda

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.2 · Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Conjuntivitis bacteriana aguda (S. aureus, neumococo, Haemophilus): secreción mucopurulenta espesa y abundante que pega los párpados y pestañas al despertar; inyección conjuntival difusa sin dolor profundo ni baja de agudeza visual.
- Diagnóstico clínico; no requiere cultivo de rutina. Descartar signos de alarma (baja de visión, dolor profundo, pupila alterada, córnea opaca o fluoresceína positiva, hipopión/hipema) que obligan a derivar.
- Tratamiento completo: aseo de secreciones con suero fisiológico y colirio de cloranfenicol 0,5 % o ciprofloxacino cada 4 horas por 7 días; ungüento nocturno si se desea. Evitar corticoides y parches oclusivos.
- Si no mejora a las 48–72 horas, derivar a oftalmología. Si hay quemosis severa, edema palpebral progresivo o fiebre, sospechar celulitis orbitaria. Forma hiperaguda (secreción en chorro, quemosis severa; N. gonorrhoeae, recién nacido de 2–5 días o adulto joven): urgencia con ceftriaxona sistémica (1 g IM/EV adulto; 25–50 mg/kg RN), lavados continuos y hospitalización.
- Seguimiento completo: control a las 48–72 horas, higiene de manos y no compartir toallas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 44

Un paciente de 35 años, con cuadro de ojo rojo asociado a secreción mucopurulenta desde hace un día, por lo cual se le indicó colirio de cloranfenicol cada 8 horas, sin embargo evoluciona posteriormente con aumento del enrojecimiento, edema palpebral y quemosis. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Alergia al cloranfenicol

B Celulitis orbitaria

C Obstrucción lacrimal

D Chalazión

E Absceso tarsal

Respuesta B. Una conjuntivitis bacteriana que, en vez de mejorar con el colirio, progresa con más edema palpebral y quemosis, dejó de ser una conjuntivitis simple: son signos de que la infección pasó al tejido orbitario, una celulitis orbitaria. La alergia al cloranfenicol es infrecuente y no explica la quemosis.

▶ VER CLASE 6.02.1.006 Conjuntivitis bacteriana crónica

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.2 · Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Conjuntivitis bacteriana crónica (>4 semanas): ojo rojo bilateral con ardor, arenilla, epífora y secreción mucosa que a veces se vuelve purulenta; suele asociarse a blefaritis estafilocócica o rosácea ocular, ojo seco o dacriocistitis crónica.
- Sospecha: curso prolongado o recidivante, pestañas con costras y bordes palpebrales eritematosos; buscar rosácea, dermatitis seborreica y uso de lentes de contacto. Chlamydia trachomatis (tracoma/conjuntivitis de inclusión) y Moraxella son causas específicas.
- Tratamiento inicial: higiene palpebral diaria (compresas tibias, shampoo suave o suero), lágrimas artificiales y antibiótico tópico (ungüento de eritromicina o cloranfenicol) 2–3 semanas; derivar con cultivo si no responde.
- Banderas rojas: baja de visión, dolor, fotofobia o córnea alterada indican compromiso corneal: derivar.
- Seguimiento: derivar a oftalmología para estudio (cultivo, descartar Chlamydia y causa de base) si es persistente o refractaria.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 75

Paciente de 32 años, con antecedentes de asma y rosácea, usuaria de corticoides inhalados, presenta un cuadro de algunos meses de evolución de ojo rojo bilateral, asociado a ardor, epífora y secreción mucosa que a veces se vuelve purulenta. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Glaucoma agudo

B Blefaritis

C Uveítis

D Dacriocistitis

E Conjuntivitis bacteriana crónica

Respuesta E. Ojo rojo superficial bilateral de más de 4 semanas, con secreción mucopurulenta intermitente, ardor y epífora, es una conjuntivitis bacteriana crónica, habitualmente asociada a blefaritis estafilocócica o rosácea. Se trata con higiene palpebral y antibiótico tópico, y se toma cultivo si no responde. El glaucoma agudo y la uveítis son ojos rojos profundos, sin secreción.

▶ VER CLASE 6.02.1.007 Conjuntivitis no infecciosa

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.2 · Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Conjuntivitis alérgica (hipersensibilidad tipo I; polen, ácaros, pelo de animales): prurito intenso y bilateral como signo cardinal, lagrimeo, secreción mucosa filante, quemosis, edema palpebral y papilas en empedrado en la conjuntiva tarsal; sin adenopatía preauricular; asociada a rinitis y atopia, estacional.
- Formas graves: queratoconjuntivitis vernal (niños varones, papilas gigantes, puntos de Trantas, riesgo corneal) y atópica (adultos con dermatitis atópica).
- Tratamiento completo en APS: evitar alérgeno, compresas frías, lágrimas artificiales sin preservantes y antihistamínico tópico de acción dual (olopatadina cada 12 horas, ketotifeno); antihistamínico oral si hay rinitis.
- Corticoides tópicos solo bajo control de oftalmología (riesgo de glaucoma, catarata y queratitis herpética); evitar colirios con vasoconstrictor crónico.
- Seguimiento: derivar a oftalmología los casos graves (vernal, atópica), refractarios o con compromiso corneal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 24 años, con rinitis alérgica, consulta en primavera por ojo rojo bilateral de 1 semana, con prurito intenso, lagrimeo y secreción mucosa filante. Al examen hay hiperemia conjuntival leve, quemosis y papilas en la conjuntiva tarsal, con agudeza visual normal y sin adenopatía preauricular. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Colirio de cloranfenicol cada 6 horas

B Colirio antihistamínico estabilizador de mastocitos, como olopatadina, y compresas frías

C Colirio de corticoide de alta potencia por 1 mes

D Colirio de aciclovir

E Oclusión ocular por 48 horas

Respuesta B. Prurito intenso, bilateral, estacional, con secreción mucosa y antecedente atópico es una conjuntivitis alérgica. Se trata con evitar el alérgeno, compresas frías, lágrimas artificiales y antihistamínicos tópicos de acción dual, como olopatadina. Los corticoides tópicos se reservan al especialista por el riesgo de glaucoma, catarata y queratitis herpética.

▶ VER CLASE 6.02.1.008 Conjuntivitis viral no complicada

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.2 · Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Conjuntivitis viral (adenovirus): secreción acuosa o serosa, sensación de arenilla, hiperemia con folículos en la conjuntiva tarsal inferior, adenopatía preauricular dolorosa (dato que confirma); empieza en un ojo y pasa al otro en 2–3 días; a veces fiebre y faringitis (fiebre faringoconjuntival).
- Muy contagiosa por contacto mano–ojo; autolimitada en 1–2 semanas. Complicación: queratitis puntata con fotofobia y visión borrosa (derivar).
- Tratamiento inicial: solo soporte: compresas frías, lágrimas artificiales sin preservantes, lavado de manos frecuente y no compartir toallas; reposo laboral o escolar por 7–10 días. No antibióticos ni corticoides.
- Sospecha de herpes (vesículas palpebrales, dendrita con fluoresceína) o signos de alarma (baja de visión, dolor profundo, fotofobia intensa, secreción purulenta en chorro): derivar de urgencia.
- Seguimiento: derivar a oftalmología si hay compromiso corneal o persiste más de 2–3 semanas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Joven de 19 años consulta por ojo derecho rojo de 48 horas de evolución, que hoy comenzó en el ojo izquierdo. Refiere sensación de arenilla, lagrimeo abundante y párpados hinchados, además de tos y odinofagia leve. Al examen: inyección conjuntival bilateral difusa, secreción serosa, y se palpa un nódulo doloroso de 1 centímetro por delante del trago auricular derecho. Agudeza visual normal en ambos ojos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar colirio de cloranfenicol cada 4 horas por 7 días

B Compresas frías, lágrimas artificiales y reposo con aislamiento por contagio

C Ceftriaxona intramuscular en monodosis

D Colirio de dexametasona cada 6 horas

E Derivar de urgencia a oftalmología en menos de 2 horas

Respuesta B. Secreción acuosa, inicio en un ojo con contagio al otro, pródromo respiratorio y adenopatía preauricular dolorosa son el cuadro típico de conjuntivitis viral por adenovirus. El manejo es de soporte, con aislamiento por el alto contagio; no lleva antibióticos, ceftriaxona ni corticoides, y no hay signos de alarma que justifiquen la derivación urgente.

▶ VER CLASE 6.02.1.009 Dacriocistitis aguda

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.3 · Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Dacriocistitis aguda: infección del saco lagrimal (S. aureus, neumococo), casi siempre sobre obstrucción crónica del conducto nasolagrimal; masa roja, caliente, tensa y dolorosa en el canto interno (región inferomedial) con epífora.
- Específico: al comprimir suavemente el saco refluye material mucopurulento por el punto lagrimal; puede haber fiebre. Complicaciones: absceso, fístula y celulitis orbitaria (edema palpebral, dolor al mover el ojo, proptosis).
- Tratamiento inicial: antibiótico oral con cobertura para estafilococo (amoxicilina-ácido clavulánico o cefadroxilo), calor local y analgesia; hospitalizar con antibiótico EV si hay signos de celulitis orbitaria, fiebre alta o niños pequeños.
- Contraindicación absoluta: no sondar ni irrigar la vía lagrimal en fase aguda (riesgo de diseminar a celulitis orbitaria); no usar solo colirios.
- Seguimiento: derivar a oftalmología; una vez resuelto el cuadro agudo, la obstrucción se trata con dacriocistorrinostomía (cirugía definitiva).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 106

Una paciente de 60 años está en espera de cirugía por obstrucción crónica del conducto nasolagrimal, sin embargo presenta cuadro de aumento de volumen en la zona medial del ojo derecho, con dolor, eritema y epífora. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar antibióticos orales

B Indicar masajes y compresiones locales

C Indicar corticoides tópicos

D Indicar antibióticos en colirios

E Resolver quirúrgicamente

Respuesta A. Paciente con obstrucción nasolagrimal crónica conocida que ahora presenta aumento de volumen, dolor, eritema y epífora en la región medial del ojo: es una dacriocistitis aguda sobre esa obstrucción de base. El tratamiento de primera línea es antibiótico oral, dejando el sondaje o la cirugía definitiva para cuando el cuadro agudo se resuelva.

▶ VER CLASE 6.02.1.010 Degeneración macular relacionada a la edad

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.14 · Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central

QUÉ HAY QUE SABER

- Degeneración macular asociada a la edad (DMAE): primera causa de ceguera central en mayores de 60–65 años; factores: edad, tabaquismo (principal modificable), antecedente familiar y raza blanca. Lesión elemental: drusas (depósitos lipídicos entre el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch).
- Seca o atrófica (85–90 %): progresión lenta en años, drusas y atrofia geográfica. Húmeda o exudativa (10–15 %, causa ~90 % de la ceguera severa): membrana neovascular coroidea por VEGF, con hemorragia subretiniana y pérdida rápida en días o semanas.
- Sospecha: metamorfopsia (líneas rectas onduladas, el síntoma más precoz), escotoma central que dificulta leer y reconocer rostros, con campo periférico siempre conservado (nunca produce ceguera total). Pesquisa en el box con rejilla de Amsler y fondo de ojo (agujero estenopeico no mejora).
- Tratamiento inicial: forma húmeda es urgencia retinológica: derivar de inmediato para inyecciones intravítreas anti-VEGF (ranibizumab, aflibercept) mensual o bimestral; forma seca: suspender tabaco, dieta con vegetales de hoja verde y suplemento AREDS-2 (vitaminas C y E, zinc, cobre, luteína y zeaxantina), que frena pero no revierte la atrofia.
- Seguimiento: derivar a oftalmología; enseñar autocontrol con rejilla de Amsler y consultar de inmediato ante cualquier distorsión nueva.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 105

Un paciente de 80 años, diabético, hipertenso y fumador de 30 paquetes-año, consulta por dificultades para leer, que ha empeorado lentamente. Además notó hace poco una metamorfopsia en el ojo izquierdo. Tiene agudeza visual de 0,8 en el ojo derecho y de 0,4 en el ojo izquierdo, y al examen ocular se aprecia leve disminución del rojo pupilar bilateral, con reflejos fotomotores normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Degeneración macular relacionada con la edad

B Glaucoma de ángulo abierto

C Desprendimiento de retina

D Glaucoma de ángulo estrecho

E Retinopatía diabética

Respuesta A. La metamorfopsia, la edad avanzada y la dificultad progresiva y lenta para leer son el cuadro característico de la degeneración macular asociada a la edad. El fumador de larga data tiene además el principal factor de riesgo modificable. El glaucoma no da metamorfopsia y afecta primero el campo visual periférico, no la lectura.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 171

Un paciente de 72 años consulta por dificultades en la lectura, que han empeorado en el último mes, a pesar de que realizó un cambio de lentes hace 6 meses. No presenta otros síntomas, tiene agudeza visual 20/80 en el ojo derecho y 20/40 en el ojo izquierdo, y refiere que ve algunos objetos deformados. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Degeneración macular relacionada con la edad

B Glaucoma crónico

C Cataratas

D Desprendimiento de retina

E Edema macular

Respuesta A. La deformación de los objetos, es decir la metamorfopsia, junto con la dificultad progresiva para leer que no mejora con un cambio de lentes reciente, orientan a degeneración macular asociada a la edad. Las cataratas dan visión borrosa difusa, sin distorsión de las formas; el glaucoma no altera la lectura fina hasta etapas muy tardías.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 68 años, hipertensa, refiere que hace 2 semanas nota que las baldosas de su cocina se ven onduladas y que le cuesta reconocer las caras de sus nietos cuando la visitan. Camina sola sin dificultad y no ha chocado con nada. Al examinarla con la rejilla de Amsler, las líneas centrales se ven curvadas hacia un punto oscuro. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tranquilizarla, ya que camina sola y no tiene compromiso de la visión periférica

B Derivar con urgencia a oftalmología para estudio con tomografía de coherencia óptica y eventual anti-VEGF

C Indicar solo antioxidantes orales con fórmula AREDS-2 y controlar en un año

D Solicitar campimetría para confirmar el diagnóstico antes de derivar

E Indicar colirio de timolol y control en tres meses

Respuesta B. Metamorfopsia y escotoma central de instalación reciente, confirmados con la rejilla de Amsler, son el cuadro cardinal de degeneración macular asociada a la edad. La evolución en solo dos semanas orienta a una forma húmeda, que exige derivación urgente para estudio con tomografía de coherencia óptica y, si se confirma, inyecciones intravítreas de anti-VEGF.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 150

Un paciente de 77 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica, presenta visión distorsionada de las letras y refiere que las líneas se ven onduladas. Actualmente tiene un escotoma central. Se hace un fondo de ojo, que se muestra a continuación: Foto 14 (https://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/01/25/medicina/1169733276.html). El diagnóstico más probable es:

A Desprendimiento de retina

B Retinopatía hipertensiva

C Trombosis de la vena central de la retina

D Catarata

E Degeneración macular relacionada con la edad

Respuesta E. Es un DMRE clásica, tanto por la clínica (metamorfopsias y escotoma central), como por el fondo de ojo (aunque se veían exudados y hemorragias maculares y no solo drusas).

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 99

Paciente hipertenso con dificultad para la lectura y visión deformada de objetos pese a lentes recientes. ¿Diagnóstico más probable?

A Retinopatía hipertensiva

B Oclusión de vena central de la retina

C Neuropatía óptica isquémica anterior

D Degeneración macular relacionada con la edad (DMRE)

E Catarata nuclear

Respuesta D. Diagnóstico: Degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) (opción D). Degeneración macular relacionada con la edad (DMRE).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 58

Una paciente de 77 años de edad consulta porque, desde hace un año y medio, ha presentado dificultades para la lectura, a pesar de haber cambiado de lentes hace 6 meses. Además, en el último tiempo, nota que ha empeorado sus dificultades para ver con el ojo derecho, con deformación de las imágenes de dicho ojo. Al examen físico, la inspección ocular no tiene alteraciones, los reflejos fotomotor y de acomodación son normales, el rojo pupilar está presenta y la oculomotilidad está conservada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Glaucoma de ángulo abierto
B Catarata
C Desprendimiento de retina
D Degeneración macular relacionada con la edad
E Neuritis óptica

Respuesta A. Diagnóstico: Glaucoma de ángulo abierto (opción A).

▶ VER CLASE 6.02.1.011 Estrabismo

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.9 · Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Estrabismo: desviación de los ejes visuales (endotropia, convergente, la más frecuente; exotropia, divergente) por alteración muscular, refractiva o neurológica; en el lactante, estrabismo intermitente y fluctuante es fisiológico hasta los 4–6 meses.
- Sospecha: reflejo corneal asimétrico en la prueba de Hirschberg, desviación al cover test, fotos con ojo desviado, inclinación de la cabeza; cualquier estrabismo constante o que persista después de los 6 meses se deriva. Descartar pseudoestrabismo por epicanto.
- Riesgo clave: ambliopía (supresión cortical del ojo desviado) cuya ventana de plasticidad se cierra a los 7–8 años; leucocoria o estrabismo súbito obligan a descartar retinoblastoma, catarata o lesión neurológica (parálisis de IV/VI par).
- Tratamiento inicial: derivar sin esperar (GES estrabismo en menores de 9 años); corrección óptica de vicios de refracción y parche sobre el ojo sano (no el ambliope) para forzar el uso del ojo flojo; cirugía correctora de músculos extraoculares en el especialista.
- Seguimiento: derivar a oftalmología pediátrica; control de agudeza visual hasta los 8–9 años.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 38

Un niño de 2 meses presenta estrabismo bilateral, fluctuante y que aparece con bastante frecuencia. Ha incrementado bien de peso y no tiene otros síntomas. Se realiza examen ocular, que muestra rojo pupilar presente bilateral, sin defectos, y movilidad ocular sin alteraciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar fondo de ojo
B Derivar a oftalmólogo pediátrico
C Indicar parches oculares intermitentes
D Solicitar tomografía computada de órbitas
E Mantener el control habitual del niño sano

Respuesta E. En los primeros meses de vida, un estrabismo intermitente, fluctuante y con reflejo rojo y motilidad normales suele ser fisiológico, porque la fijación binocular aún no ha madurado. No exige derivación ni exámenes de urgencia; sí lo haría si fuera fijo, constante, o si alterara el reflejo rojo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Madre consulta en control infantil con su hijo de 4 años porque nota que en las fotografías familiares el ojo izquierdo del niño parece desviarse levemente hacia la nariz. Al examen: agudeza visual en ojo derecho 20/20 y en ojo izquierdo 20/80, que no mejora al mirar por el agujero estenopeico. Medios transparentes y fondo de ojo normal. La prueba de Hirschberg revela asimetría en el reflejo corneal del ojo izquierdo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tranquilizar a la madre: es normal que un niño de esa edad desvíe levemente un ojo
B Prescribir lentes ópticos y controlar la agudeza visual en un año
C Derivar de urgencia a oftalmología pediátrica para corrección óptica y terapia con parche en el ojo derecho
D Solicitar resonancia magnética de órbita antes de decidir cualquier tratamiento
E Indicar parche en el ojo izquierdo, que es el ojo con menor agudeza visual

Respuesta C. Estrabismo con endotropia y agudeza visual 20/80 en el ojo desviado, que no mejora con agujero estenopeico y con fondo de ojo normal: ambliopía estrábica. Es GES 41 (estrabismo en menores de 9 años); la conducta es corrección óptica y parche en el ojo sano, el derecho, antes de que se cierre la ventana de plasticidad a los 7-8 años.

▶ VER CLASE 6.02.1.012 Glaucoma congénito

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.7 · Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG

QUÉ HAY QUE SABER

- Glaucoma congénito (primario): malformación del ángulo con PIO elevada en lactantes; la presión distiende el globo aún elástico. Más frecuente en varones, bilateral en ~70 %.
- Sospecha: tríada epífora, fotofobia y blefarospasmo, más córnea opaca (edema) y aumento del diámetro corneal (buftalmo, ojos «grandes y hermosos»); estrías de Haab. Diferenciar de obstrucción lagrimal (epífora con córnea normal), megalocórnea y distrofias corneales.

- Manejo inicial: urgencia de derivación, no iniciar colirios ni parches; el tratamiento es quirúrgico (goniotomía o trabeculotomía) y precoz; los fármacos hipotensores son solo puente.
- Complicaciones si se retrasa: ceguera por daño del nervio óptico, ambliopía y opacidad corneal permanente.
- Seguimiento: derivar de inmediato a oftalmología pediátrica; control de por vida de PIO, campo visual y refracción.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 31

Lactante de 5 meses presenta opacidad corneal bilateral, asociada a epífora y aumento del diámetro corneal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Retinoblastoma
B Macrocórnea
C Glaucoma congénito
D Atresia lagrimal
E Catarata congénita

Respuesta C. Epífora, fotofobia, blefaroespasmo, córnea opaca (edema) y aumento del diámetro corneal (buftalmo) en un lactante son glaucoma congénito: la presión intraocular elevada distiende el globo ocular aún elástico. Es una urgencia de derivación porque su tratamiento es quirúrgico. La atresia lagrimal da epífora con córnea normal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 83

Un lactante de 5 meses, con antecedente de haber nacido a las 35 semanas, presenta cambios en el aspecto de sus ojos, sin otros síntomas. Se realiza medición del diámetro corneal, que resulta 14 mm (VN: 10 a 12 mm) y prueba de fluoresceína, con aclaramiento de 5 minutos. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?

A Glaucoma congénito
B Atresia de la vía lagrimal
C Conjuntivitis por Chlamydia trachomatis
D Ambliopía
E Retinopatía del prematuro

Respuesta A. Glaucoma Congénito: La epífora, megalocórnea y buftalmos sugieren glaucoma congénito. La prueba de fluoresceína con aclaramiento lento es compatible con dacriocistitis congénita y glaucoma congénito. El valor normal del aclaramiento de fluoresceína es menor a 5 minutos.

▶ VER CLASE 6.02.1.013 Glaucoma crónico

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.7 · Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG

QUÉ HAY QUE SABER

- Glaucoma crónico de ángulo abierto: neuropatía óptica progresiva por mala función de la malla trabecular; es la primera causa de ceguera irreversible. Silencioso: sin dolor, sin ojo rojo y con agudeza visual 20/20 hasta etapas terminales.
- Factores de riesgo: PIO >21 mmHg (aunque hasta 40 % es de presión normal), edad, familiar de primer grado (predictor más fuerte), raza negra, miopía alta, diabetes. Daño de fibras periféricas: escotoma de Bjerrum, escalón nasal y luego visión en túnel.
- Sospecha en APS con fondo de ojo: excavación papilar >0,5 o asimetría entre ambos ojos >0,2, muescas del anillo neurorretiniano y vasos nasalizados. Una agudeza visual normal no descarta el diagnóstico.
- Confirmación por oftalmología: tonometría, gonioscopía (ángulo abierto), campimetría computarizada y OCT de fibras nerviosas. Tratamiento de por vida: colirio de análogo de prostaglandina (latanoprost, una gota nocturna; oscurece el iris y alarga pestañas), betabloqueador (timolol; contraindicado en asma y bloqueo AV), trabeculoplastía o trabeculectomía si progresa. GES glaucoma.
- Seguimiento: derivar a oftalmología; pesquisar activamente a familiares de primer grado y a mayores de 40 años con factores de riesgo.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 147

Un paciente de 42 años se realiza una tonometría ocular que informa una presión intraocular de 27 mmHg. Presenta una excavación papilar de 0,7 en el ojo derecho, y en la gonioscopía se observa ángulo abierto en todo el contorno del iris. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Retinopatía diabética
B Neuritis óptica
C Glaucoma crónico
D Coriorretinitis
E Degeneración macular relacionada con la edad

Respuesta C. Presión intraocular elevada, excavación papilar aumentada, con gonioscopía que confirma el ángulo abierto: glaucoma crónico de ángulo abierto, el diagnóstico que arma exactamente esta tríada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 166

Un paciente de 60 años, diabético, hipertenso y dislipidémico, consulta por disminución progresiva de la calidad de la visión. A su examen físico, la exploración ocular es normal, con rojo pupilar normal bilateral. La agudeza visual es 20/25 en ambos ojos. La campimetría muestra defectos en los dos cuadrantes superiores del campo visual izquierdo y en los dos cuadrantes mediales del campo visual derecho. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Degeneración macular relacionada con la edad
B Tumor del lóbulo occipital
C Catarata
D Glaucoma crónico
E Neuropatía óptica isquémica

Respuesta D. Agudeza visual conservada, con defectos de campo visual periféricos y asimétricos entre ambos ojos, y examen ocular externo normal: patrón clásico de glaucoma crónico. La degeneración macular y la catarata afectan la agudeza visual; un tumor occipital daría una hemianopsia homónima, no este patrón bimedial.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 84

Una paciente de 50 años se realiza una tonomotría ocular, que muestra una presión intraocular de 28 mmHg en el ojo derecho. La inspección ocular no tiene alteracios. La agudeza visual es 1,0 en ambos ojos y se constata una excavación papilar es de 0,7 a derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Degeneración macular relacionada con la edad
B Neuropatía óptica
C Glaucoma crónico
D Catarata
E Desprendimiento de retina

Respuesta C. Es un glaucoma crónico clásico, tanto por la PIO mayor a 20, como por la excavación papilar mayor a 0,3.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 155

Una paciente de 67 años, con antecedente de artritis reumatoide, en tratamiento con metotrexato y prednisona, consulta por dificultades para ver. Tiene historia de cirugía de cataratas hace dos años. Al examen oftalmológico se constata agudeza vidual 20/25 a derecha y 20/30 a izquierda y, en la campimetría visual, se observa afectación de la zona medial del campo visual derecho y de la zona superior del campo visual izquierdo. El diagnóstico más probable es:

A Desprendimiento de retina
B Lesión del quiasma óptico
C Glaucoma crónico
D Neuritis óptica
E Degeneración macular relacionada con la edad

Respuesta C. Tiene agudeza visual normal, pero afectación del campo visual, lo que sugiere un glaucoma crónico. Se asocia al uso de corticoides y alos factores de riesgo cardiovascular.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 114

Paciente con glaucoma crónico, con ojo izquierdo con visión en túnel y ojo derecho con el signo de humo de chimenea, al evaluar el ojo con glaucoma crónico, ¿qué hallazgo tendría?:

A Midriasis arreflectica
B Reflejo ?/
C Miosis
D Defecto pupilar aferente (esta porque la principal complicación del glaucoma crónico es el daño del nervio óptico que se vería con un DPA)
E Ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Midriasis arreflectica).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 163

Paciente con vision tubular, y un signo de humo de chimenea en el ojo _. Visión derecho digital? e izq 20/20. Reflejo fotomotor alterno/RFM alterado creo . ¿Cuál es el diagnóstico? ALGUIEN QUE MEJORE ESTA PREGUNTA A LAS ALTERNATIVAS: me parece que esta tenía glaucoma de ángulo abierto en las alternativas?

A Hemograma y VHS
B Ecografía
C Radiografía
D TAC con contraste
E Resonancia magnética

Respuesta A. Diagnóstico: Hemograma y VHS (opción A).

▶ VER CLASE | 6.02.1.014 | **Hifema** | DX ESPECÍFICO | TX INICIAL | SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.15 · Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Hifema (hipema) traumático: sangre en la cámara anterior por rotura de vasos del iris o cuerpo ciliar tras un trauma contuso (puñetazo, pelota); se ve un nivel de sangre en el sector inferior de la cámara anterior, con baja visual y dolor. Es un trauma cerrado, pero descartar globo abierto.
- Específico: graduar por la altura del nivel (<1/3, 1/3–1/2, >1/2, total). Buscar signos de globo abierto (pupila en gota, Seidel positivo, hipotonía) antes de manipular; investigar anemia falciforme y anticoagulantes.
- Tratamiento inicial: reposo con cabecera elevada a 30–45° para que los eritrocitos decanten, protector ocular rígido sin compresión, analgesia con paracetamol y evitar aspirina y AINE (alteran la hemostasia); antiemético si hay náuseas.
- Complicaciones: resangrado a las 48–72 horas (suele ser mayor que el inicial), glaucoma secundario agudo y tinción hemática de la córnea; el drenaje quirúrgico se reserva para casos complicados.
- Seguimiento: derivar a oftalmología para vigilancia diaria de la presión intraocular y tratamiento hipotensor si corresponde.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un obrero de la construcción acude a un centro de urgencias tras recibir el impacto de un clavo en el ojo izquierdo. Al examen físico el paciente se encuentra muy quejumbroso, la agudeza visual en el ojo izquierdo es de bultos a 30 cm, la pupila está desfigurada en forma de pera apuntando hacia la hora 2, y se observa una cámara anterior muy plana con salida de un filamento negruzco a través de una incisión en la córnea. **¿Cuál de las siguientes conductas representa una acción estrictamente contraindicada en este paciente?**

A Instalar una concha o protector rígido fenestrado plástico fijado con tela adhesiva

B Administrar analgesia y antieméticos por vía endovenosa

C Realizar tonometría aplanática para cuantificar el grado de hipotonía ocular

D Indicar ayuno absoluto y solicitar evaluación urgente por oftalmología

E Administrar vacuna antitetánica si no tiene dosis de refuerzo reciente

Respuesta C. Ante signos inequívocos de globo ocular abierto (pupila en gota con herniación de tejido uveal y atalamia), medir la presión intraocular está estrictamente contraindicado: el contacto del tonómetro presiona el ojo y puede expulsar el contenido intraocular. La protección con concha rígida, la analgesia y antieméticos EV, y el ayuno son conductas mandatorias.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 22 años recibe un pelotazo de fútbol en el ojo izquierdo hace 3 horas. Refiere visión borrosa. Al examen: agudeza visual 20/50, nivel de sangre de 2 mm en la cámara anterior inferior, córnea transparente, sin laceraciones ni deformación pupilar. No tiene antecedentes de anemia de células falciformes ni usa anticoagulantes. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Reposo con cabecera elevada a 30-45 grados, protector ocular rígido, evitar AINE y derivar a oftalmología para control de presión intraocular

B Alta con ibuprofeno para el dolor y control en una semana

C Masaje ocular para redistribuir la sangre y parche compresivo

D Drenaje inmediato de la cámara anterior en el servicio de urgencia

E Colirio de pilocarpina cada 6 horas y control en 48 horas

Respuesta A. El hifema traumático se maneja con reposo semisentado, protector rígido (sin compresión), evitar AINE y aspirina por riesgo de resangrado y derivación a oftalmología, que vigila la presión intraocular y la tinción hemática corneal. El drenaje quirúrgico se reserva para casos complicados.

▶ VER CLASE 6.02.1.015 Leucoma corneal

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.4 · Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)

QUÉ HAY QUE SABER

- Leucoma corneal: cicatriz corneal blanca, densa y bien delimitada, secuela de úlceras (bacterianas, herpéticas), traumas, quemaduras químicas o queratitis; ojo blanco, sin dolor, que no tiñe con fluoresceína (a diferencia de la úlcera activa).
- Específico: antecedente de úlcera o trauma corneal, opacidad central o paracentral y baja de agudeza visual; en niños puede causar ambliopía por privación visual.
- Tratamiento inicial en APS: confirmar con fluoresceína que no hay úlcera activa, lubricación y protección ocular; no usar corticoides ni antibióticos sin indicación; evitar frotar el ojo.
- Si es central y compromete la visión: queratoplastía (trasplante de córnea) o rehabilitación óptica por oftalmología; en lactantes derivar urgente por riesgo de ambliopía.
- Seguimiento: derivar a oftalmología para evaluar trasplante, corrección óptica y control de ambliopía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 50 años con antecedente de úlcera corneal bacteriana en el ojo derecho hace 1 año, tratada. Consulta por visión borrosa persistente de ese ojo. Al examen se observa una opacidad blanca, densa y bien delimitada en el centro de la córnea, que no tiñe con fluoresceína. El ojo está blanco y sin dolor. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?**

A Úlcera corneal activa; antibiótico tópico

B Catarata; facoemulsificación

C Leucoma corneal central; derivar a oftalmología para evaluar queratoplastía (trasplante de córnea)

D Pterigion; exéresis

E Queratitis herpética; aciclovir

Respuesta C. El leucoma es una cicatriz corneal blanca y densa, secuela de úlceras, traumas o queratitis. Si es central, disminuye la agudeza visual y en niños puede causar ambliopía. Se diferencia de la úlcera activa porque no tiñe con fluoresceína y el ojo está tranquilo. El tratamiento de un leucoma central que compromete la visión es la queratoplastía.

▶ VER CLASE 6.02.1.016 **Neuritis óptica** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.18 · Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

QUÉ HAY QUE SABER

- Neuritis óptica: inflamación desmielinizante autoinmune del nervio óptico; mujer joven (20–40 años) con baja visual monocular subaguda en horas a 2–3 días, dolor periocular que aumenta al mover el ojo (>90 %) y discromatopsia (rojo descolorido).
- Sospecha: defecto pupilar aferente relativo (pupila de Marcus Gunn, el signo objetivo más sensible) y fondo de ojo normal en ~65 % (neuritis retrobulbar); en ~35 % papilitis con edema leve de papila. No descartarla por tener fondo de ojo normal.
- Asociación con esclerosis múltiple (~50 % a futuro; GES de sospecha de esclerosis múltiple): solicitar resonancia de encéfalo y órbitas con gadolinio, que predice el riesgo.
- Tratamiento inicial: derivar con pulsos de metilprednisolona EV 1 g/día por 3–5 días y luego prednisona oral decreciente; prednisona oral sola a dosis bajas está contraindicada (estudio ONTT: duplica las recurrencias).
- Seguimiento: derivar a oftalmología/neurología para estudio de esclerosis múltiple; diferenciar de papiledema (bilateral, AV conservada, sin dolor ocular), de neuropatía isquémica (>50 años, indolora) y de compresión tumoral.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 5

Una paciente de 26 años, con antecedente de esclerosis múltiple consulta por disminución de la agudeza visual derecha, de 2 días de evolución, asociado a leve dolor retroocular derecho, que aumenta con los movimientos. Al examen físico se aprecia rojo pupilar y movimientos normales, escape pupilar, con defecto pupilar aferente en el ojo derecho y presencia de un escotoma derecho. **¿Cuál es el diagnóstico más probale?**

A Desprendimiento de retina

B Trombosis de la vena central de la retina

C Trombosis de arteria central de la retina

D Neuritis óptica

E Absceso orbitario

Respuesta D. Baja visual en días, dolor retroocular que aumenta con los movimientos oculares y defecto pupilar aferente, en una paciente con esclerosis múltiple: neuritis óptica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 82

Una paciente, con antecedente de esclerosis múltiple, consulta por dolor ocular derecho, de 2 días de evolución, a lo que se le ha agregado visión borrosa. Tiene agudeza visual de 0,9 en el lado derecho y 1 en el lado izquierdo, que no cambia al mirar por un agujero estenopeico. Además se constata que en el ojo derecho está muy afectada la visión de colores. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Discromatopsia

B Retinitis pigmentosa

C Coriorretinitis

D Desprendimiento de retina

E Neuritis óptica

Respuesta E. Dolor ocular y visión borrosa de días, con gran compromiso de la visión de colores aunque la agudeza visual esté casi normal, en una paciente con esclerosis múltiple: neuritis óptica. La discromatopsia es un signo, no el diagnóstico.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 27 años consulta por disminución progresiva de la visión en su ojo derecho de 3 días de evolución, con dolor sordo retroocular que aumenta al mirar hacia los lados o hacia arriba. Refiere que los objetos rojos los ve descoloridos o cafés con ese ojo. Al examen: agudeza visual OD 20/100, OI 20/20. Con la linterna oscilante, al iluminar el ojo izquierdo hay miosis bilateral rápida, pero al pasar la luz al ojo derecho ambas pupilas se dilatan paradójicamente. El fondo de ojo no muestra alteraciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tranquilizarla, ya que el fondo de ojo es normal y no hay patología ocular

B Solicitar resonancia magnética de encéfalo y órbitas con gadolinio, e iniciar pulsos de metilprednisolona endovenosa

C Indicar prednisona oral a dosis bajas y controlar en dos semanas

D Realizar punción lumbar de inmediato para medir la presión de apertura

E Solicitar tomografía computada de órbita con contraste para descartar celulitis orbitaria

Respuesta B. La baja visual monocular subaguda, el dolor con los movimientos oculares, la discromatopsia para el rojo, el defecto pupilar aferente relativo y el fondo de ojo normal arman el cuadro de neuritis óptica retrobulbar. La conducta es resonancia con gadolinio para evaluar el riesgo de esclerosis múltiple e iniciar pulsos de metilprednisolona endovenosa; la prednisona oral sola está contraindicada.

▶ VER CLASE 6.02.1.017 Neuropatía óptica isquémica

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.21 · Vasculitis de Vaso Grande y Mediano: Arteritis de la Temporal (Células Gigantes / Urgencia Visual) y Arteritis de Takayasu

QUÉ HAY QUE SABER

- Neuropatía óptica isquémica anterior: infarto de la cabeza del nervio óptico; pérdida visual brusca e indolora, edema de papila (pálido en la arterítica) con hemorragias peripapilares en llama y defecto pupilar aferente.
- Arterítica (arteritis de células gigantes): >50 años, cefalea temporal de nuevo inicio, claudicación mandibular (el signo más específico), alodinia del cuero cabelludo, polimialgia reumática, VHS/PCR muy elevadas; ceguera irreversible y riesgo >50 % de afectar el otro ojo en 24–48 horas. No arterítica: factores vasculares (HTA, diabetes, apnea del sueño, papila pequeña «de riesgo»).
- Regla de oro: ante sospecha de arteritis temporal iniciar corticoides inmediatamente sin esperar la biopsia (metilprednisolona EV en pulsos si hay síntomas visuales; prednisona 1 mg/kg/día si no los hay); biopsia de arteria temporal de al menos 1,5–2 cm o ecografía Doppler (signo del halo).
- Tratamiento inicial: derivar de urgencia, pedir VHS, PCR y hemograma; tocilizumab como ahorrador de corticoides en recaídas; antiagregación según indicación y control de factores de riesgo vascular en la forma no arterítica.
- Seguimiento: derivar a oftalmología y reumatología; descenso lento de corticoides con profilaxis de osteoporosis.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 72 años consulta por cefalea frontotemporal derecha intensa de 3 semanas, acompañada de dolor en la mandíbula al masticar que lo obliga a detenerse durante las comidas y dolor en cuero cabelludo al peinarse. Hace 24 horas presentó un episodio transitorio de pérdida de visión en el ojo derecho de 10 minutos de duración (amaurosis fugax). Al examen físico la arteria temporal derecha se palpa indurada, tortuosa y con pulso disminuido. El laboratorio muestra una VSG de 95 mm/h y PCR de 48 mg/L. **¿Cuál es la sospecha diagnóstica principal y cuál es la conducta médica inmediata e ineludible?**

A Arteritis de células gigantes (temporal); hospitalizar de inmediato para iniciar pulsos de corticoides endovenosos sin esperar la biopsia arterial

B Neuralgia del trigémino; iniciar carbamazepina oral y derivar a neurología ambulatoria

C Accidente isquémico transitorio carotídeo; iniciar aspirina 100 mg y solicitar angio-TC cerebral urgente

D Arteritis temporal incipiente; programar biopsia de arteria temporal e iniciar corticoides solo tras recibir el informe histológico

E Cefalea tensional en el adulto mayor; prescribir paracetamol con relajante muscular y reposo

Respuesta A. El cuadro clínico reúne todos los criterios de la Arteritis de Células Gigantes (Arteritis de la Temporal): paciente > 50 años (72 años), cefalea de nuevo inicio, hipersensibilidad del cuero cabelludo, claudicación mandibular (el síntoma más específico), arteria temporal indurada, VSG > 50 mm/h y un síntoma de alarma oftalmológica extrema: amaurosis fugax. La presencia de síntomas visuales confiere un riesgo inminente de ceguera irreversible bilateral. La conducta médica inmediata e ineludible...

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 156

Un paciente de 65 años, con antecedente de revascularización miocárdica hace un año y cirugía de cataratas, consulta porque hace algunas horas dejó de ver su pie derecho. No ha presentado otros síntomas. Al examen físico se aprecia oculomotilidad normal, inspección normal y defecto pupilar aferente relativo en el ojo derecho. La campimetría muestra pérdida del campo visual inferior del ojo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Neuritis óptica

B Degeneración macular relacionada con la edad

C Accidente vascular encefálico occipital

D Edema macular

E Neuropatía óptica isquémica

Respuesta E. Tiene una amaurosis parcial súbita, lo que sugiere fuertemente una neuropatía óptica isquémica. Por ser la parte inferior del campo visual izquierdo lo afectado, probablemente la lesión se produjo en la parte superior del nervio óptico izquierdo. La neuritis óptica se instala en horas o días, la DMRE demora meses o años, el edema macular demora días y el accidente vascular occipital tiene una hemianopsia contralateral, afectado ambos campos visuales. Finalmente, también podría haber sido un...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 170

Un paciente de 70 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y revascularización coronaria hace 3 años, consulta porque hace pocas horas notó que, de forma súbita, dejó de ver su pierna derecha con el ojo derecho. Al examen físico presenta inspección ocular normal, agudeza visual 20/30 en el ojo derecho y 20/20 en el ojo izquierdo, pupilas isocóricas con defecto pupilar aferente relativo, y en la campimetría por confrontación se observa hemianopsia inferior del ojo derecho. El diagnóstico más probable es:

A Neuri2s óp2ca isquémica
B Infarto del lóbulo occipital
C Desprendimiento de re2na
D Glaucoma
E Degeneración macular relacionada con la edad

Respuesta A. Tanto por el inicio súbito, con factores de riesgo cardiovascular, como por el defecto pupilar aferente relativo (DPAR), es una neuropatía óptica isquémica, con afectación de la zona superior del nervio óptico derecho (inerva la zona superior de la retina y corresponde a la zona inferior del campo visual). El DPAR se ve también en la neuritis óptica desmielinizante y en el desprendimiento de retina extenso o en la oclusión de la arteria central de la retina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 153

Un paciente de 64 años, con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y tabaquismo, presenta pérdida de la visión del ojo izquierdo, con instalación súbita. Al examen, es capaz de distinguir la luz de la sombra y contar dedos y destaca defecto pupilar aferente relativo. El diagnóstico más probable es:

A Glaucoma agudo
B Glaucoma crónico terminal
C Neuritis óptica
D Neuropatía óptica isquémica
E Desprendimiento de retina

Respuesta D. Parecía una trombosis de la vena central, pero no aparece en las opciones. Por tener DPAR (defecto pupilar aferente relativo) sugiere un desprendimiento de retina, pero le falta tener fotopsias o entopsias que antecedan. Así, dados los antecedentes, lo más probable es la neuropatía óptica isquémica. No puede ser una neuritis óptica, porque esta no es súbita, sino que aparece en varias horas.

▶ VER CLASE 6.02.1.018 Obstrucción completa de la vía lacrimal

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.3 · Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Obstrucción de la vía lagrimal: lagrimeo continuo (epífora) por falla en el drenaje. Congénita (6–20 % de recién nacidos, membrana de Hasner imperforada): epífora y secreción desde las primeras semanas, ojo blanco, reflujo de material al comprimir el saco; en adultos por estenosis involutiva, traumas o infecciones.
- Específico: diagnóstico clínico (epífora crónica, reflujo por el punto lagrimal a la presión del saco, test de desaparición de fluoresceína alterado); diferenciar de glaucoma congénito (epífora con fotofobia, córnea grande y turbia), conjuntivitis y dacriocele.
- Tratamiento inicial en el lactante: masaje del saco lagrimal (maniobra de Crigler) 2–3 veces al día, aseo con suero fisiológico y antibiótico tópico solo si hay sobreinfección; >90 % se resuelve antes del año.
- Si persiste después de los 6–12 meses: sondaje de la vía lagrimal por oftalmología. En el adulto con obstrucción completa: dacriocistorrinostomía; no sondar durante dacriocistitis aguda.
- Seguimiento: derivar a oftalmología; derivar antes si hay dacriocele, dacriocistitis, celulitis o sospecha de glaucoma congénito.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 60

Niño de 4 meses consulta por epífora del ojo izquierdo y eritema, que no ha respondido al uso de antibióticos tópicos. Al examen físico se aprecia edema y aumento de volumen de la zona medial (canto interno), con reflujo de secreción al comprimir el saco lagrimal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Glaucoma congénito
B Conjuntivitis bacteriana
C Atresia lagrimal congénita
D Queratitis por Chlamydia trachomatis
E Dacriocele

Respuesta C. La obstrucción congénita del conducto nasolagrimal (membrana de Hasner imperforada) da epífora y secreción con reflujo a la compresión del saco, en un ojo sin otras alteraciones. Se maneja con masaje del saco lagrimal (Crigler) y aseo; la mayoría se resuelve antes del año, y si persiste se indica sondaje. El dacriocele es una masa azulada presente al nacer.

▶ VER CLASE 6.02.1.019 Orzuelo no complicado

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.3 · Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Orzuelo (hordeolum): infección aguda de glándulas de Zeiss y Moll (externo, en la base de una pestaña) o de Meibomio (interno), casi siempre por S. aureus; nódulo eritematoso, caliente y muy doloroso, a veces con pústula.

- Específico: diagnóstico clínico; distinguir de chalazión (indoloro, crónico), dacriocistitis (canto interno) y celulitis preseptal (edema y eritema difuso del párpado, fiebre).
- Tratamiento completo: compresas tibias húmedas 3–4 veces al día para favorecer el drenaje espontáneo, higiene palpebral y ungüento oftálmico antibiótico (eritromicina o cloranfenicol).
- No puncionar ni exprimir de forma precoz; antibiótico oral solo si hay celulitis circundante. No usar corticoides.
- Seguimiento completo: resuelve en 5–7 días; derivar si no drena, evoluciona a chalazión persistente o hay celulitis preseptal/orbitaria.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 30 años consulta por un nódulo doloroso, eritematoso, de 3 días de evolución, en el párpado superior derecho, localizado en la base de una pestaña. No refiere fiebre ni baja de visión. Al examen: pústula pequeña y sensible en el borde palpebral, sin compromiso de la conjuntiva tarsal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Punción y drenaje inmediato en el box

B Compresas tibias 3 a 4 veces al día más ungüento oftálmico antibiótico

C Curetaje quirúrgico ambulatorio

D Infiltración de triamcinolona intralesional

E Colirio de corticoide tópico cada 6 horas

Respuesta B. Nódulo agudo, eritematoso y doloroso en la base de una pestaña es un orzuelo externo. El tratamiento es compresas tibias, que favorecen el drenaje espontáneo, más un ungüento antibiótico; no se punciona de forma precoz. El curetaje y la triamcinolona son manejo del chalazión, y el corticoide tópico no tiene rol aquí.

▶ VER CLASE 6.02.1.020 Pterigion

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.1 · Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo

QUÉ HAY QUE SABER

- Pterigion: pliegue fibrovascular triangular de conjuntiva bulbar (habitualmente nasal) que invade la córnea; asociado a exposición UV, viento y polvo (pescadores, agricultores). Sensación de cuerpo extraño, ojo rojo recurrente; agudeza visual normal salvo que llegue al eje visual.
- Específico: se diagnostica por inspección; distinguir de pinguécula (engrosamiento amarillento conjuntival que no invade la córnea) y de tumores conjuntivales (aspecto leucoplásico, vascularización atípica).
- Tratamiento inicial: lágrimas artificiales, protección solar con lentes con filtro UV y sombrero; antiinflamatorio tópico solo en episodios inflamatorios (corticoide únicamente indicado por oftalmólogo).
- Cirugía (exéresis con autoinjerto conjuntival para disminuir recidiva) cuando amenaza el eje visual, induce astigmatismo, limita la motilidad o por estética.
- Seguimiento: derivar a oftalmología para control periódico y cirugía si progresa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 52 años, pescador, consulta por sensación de cuerpo extraño y enrojecimiento del ojo derecho. Al examen se observa un pliegue fibrovascular triangular de conjuntiva bulbar nasal que invade 2 mm la córnea. La agudeza visual es normal. **¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A Exéresis quirúrgica inmediata

B Biopsia urgente

C Corticoide tópico crónico

D Antibiótico tópico

E Lubricantes tópicos, protección solar con lentes con filtro UV y control; cirugía si progresa hacia el eje visual o produce astigmatismo

Respuesta E. El pterigion es una proliferación fibrovascular de la conjuntiva que invade la córnea, asociada a exposición UV, viento y polvo. Se maneja con lubricantes, antiinflamatorios en reagudizaciones y protección solar. La cirugía (con autoinjerto conjuntival para reducir recidiva) se indica si amenaza el eje visual, induce astigmatismo, limita la motilidad o por estética.

▶ VER CLASE 6.02.1.021 Queratitis

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.1 · Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo
Oftalmología 15.4 · Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)

QUÉ HAY QUE SABER

- Queratitis: inflamación o infección de la córnea. Ojo rojo con inyección ciliar, dolor punzante, blefarospasmo, fotofobia y lagrimeo; la córnea se tiñe con fluoresceína bajo luz azul de cobalto (examen de cabecera).
- Herpética (VHS-1): úlcera dendrítica ramificada con botones terminales, hipoestesia corneal, recidiva con fiebre o estrés. Bacteriana: infiltrado blanco denso con defecto epitelial y a menudo hipopión, en usuarios de lentes de contacto blandos (Pseudomonas). Actínica: dolor bilateral horas después de exposición UV sin protección, cura en 24–48 horas.
- Tratamiento inicial: derivación prioritaria a oftalmología (el mismo día si es bacteriana); herpética: aciclovir ungüento oftálmico 3 % cinco veces al día por 10–14 días; bacteriana: retirar y guardar los lentes para cultivo, antibióticos reforzados (vancomicina + ceftazidima o moxifloxacino) y no ocluir con parche.
- Regla de oro: JAMÁS corticoides tópicos en una úlcera corneal sospechada o confirmada (transforman la dendrita en úlcera geográfica y pueden perforar); tampoco anestésico tópico repetido ni midriáticos. Ciclopléjico para el dolor por espasmo ciliar.

- Seguimiento: derivar a oftalmología; control estrecho hasta cicatrización y rehabilitación visual si deja leucoma.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 156

Una paciente de 42 años consulta por dolor ocular derecho, asociado a ojo rojo que inició hace 5 horas y se ha vuelto muy intenso. Al examen físico, presenta epífora y ojo rojo derecho de tipo central. Como antecedente, tiene astigmatismo y es usuaria de lentes de contacto. **¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?**

A Fondo de ojo
B Tonometría ocular
C TAC de órbitas
D Tinción con fluoresceína
E Gonioscopía

Respuesta D. Usuaria de lentes de contacto, con dolor ocular agudo, ojo rojo central y epífora: la sospecha es una queratitis o una erosión corneal. El examen que confirma la lesión epitelial de la córnea es la tinción con fluoresceína bajo luz azul de cobalto, no la tonometría ni la gonioscopía, que son propias del estudio del glaucoma.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 35 años consulta por dolor ocular derecho punzante, fotofobia intensa y lagrimeo de 2 días de evolución. Al teñir la córnea con una gota de fluoresceína y observar bajo luz azul de cobalto, se aprecia una lesión epitelial corneal superficial de aspecto arborescente y ramificado, con extremos bulbosos. **¿Cuál de los siguientes fármacos está formalmente contraindicado por el riesgo de inducir perforación corneal?**

A Aciclovir ungüento oftálmico al 3 por ciento
B Ganciclovir gel oftálmico al 0,15 por ciento
C Dexametasona colirio oftálmico al 0,1 por ciento
D Ciclopentolato colirio al 1 por ciento
E Lágrimas artificiales de hialuronato de sodio

Respuesta C. La lesión descrita, arborescente y con botones terminales, es una úlcera dendrítica herpética. Los corticoides tópicos, como la dexametasona, están terminantemente contraindicados: inhiben la inmunidad local, favorecen la replicación viral y pueden transformar la dendrita en una úlcera geográfica con perforación corneal.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Joven de 28 años consulta por ojo derecho muy rojo, doloroso y con fotofobia intensa de 24 horas de evolución. Refiere antecedente de herpes labial recurrente. Al examen: inyección periquerática intensa. La tinción con fluoresceína bajo filtro azul de cobalto revela una úlcera epitelial ramificada, en forma de dendrita, con botones terminales en el tercio central de la córnea. **¿Cuál es la conducta más adecuada en atención primaria?**

A Aciclovir en pomada oftálmica al 3 por ciento, 5 veces al día, y derivar a oftalmología
B Colirio de dexametasona cada 4 horas y control en 1 semana
C Colirio de cloranfenicol y parche ocular oclusivo
D Colirio anestésico para el dolor y alta con reposo
E Colirio de ciprofloxacino reforzado y derivar en 1 semana

Respuesta A. Úlcera dendrítica con botones terminales, en un paciente con antecedente de herpes labial, es queratitis herpética. El tratamiento correcto es aciclovir tópico y derivación a oftalmología; el corticoide está formalmente contraindicado, y ni el antibiótico ni el anestésico tópico repetido tienen un rol aquí.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 19

Una paciente de 45 años con antecedente de artritis reumatoide, en tratamiento con micofenolato y terapia biológica, consulta por dolor ocular, epífora y ojo rojo bilateral asociado a fotofobia. Refiere que los síntomas empeoran en la tarde, al término de su jornada laboral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Quera22s
B Uveí2s
C Glaucoma agudo
D Conjun2vi2s viral
E Celuli2s orbitaria

Respuesta A. Una paciente con artritis reumatoide puede desarrollar síndrome de Sjögren secundario, que produce ojo seco y queratitis sicca. Los síntomas que empeoran en la tarde, tras una jornada de uso visual, son típicos de ojo seco. La uveítis suele dar dolor y fotofobia intensos sin ese patrón, y el glaucoma agudo y la celulitis orbitaria tienen otro cuadro clínico.

▶ VER CLASE 6.02.1.022 **Retinopatía del prematuro** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.16 · Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal

QUÉ HAY QUE SABER

- Retinopatía del prematuro (ROP): vasculopatía proliferativa de la retina inmadura, favorecida por prematurez, bajo peso e hiperoxia; puede evolucionar a neovascularización, desprendimiento de retina y ceguera.
- Sospecha/pesquisa: todo prematuro <32 semanas o <1.500 g (y los mayores con oxígeno prolongado o inestabilidad) tiene garantía GES de tamizaje con fondo de ojo dilatado por oftalmólogo, desde alrededor de las 4 semanas de vida (o 31 semanas de edad posmenstrual); no esperar leucocoria, que indica retina ya

desprendida.

- Manejo inicial: el neonatólogo coordina el tamizaje; mantener oxigenoterapia con saturación controlada y buen aporte nutricional; derivar a oftalmología para clasificar por zona, estadio y enfermedad «plus».
- Tratamiento por oftalmología según gravedad: láser de la retina avascular o antiangiogénicos intravítreos (bevacizumab/ranibizumab); cirugía en desprendimiento.
- Seguimiento: controles oftalmológicos seriados hasta la vascularización completa y luego anual por miopía, estrabismo y ambliopía; derivar de inmediato ante leucocoria o estrabismo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de 29 semanas de gestación y 1.150 g de peso al nacer, que requirió oxigenoterapia prolongada. Se encuentra en la unidad de neonatología a las 4 semanas de vida. **Respecto de la retinopatía del prematuro, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A No requiere evaluación, porque está en oxígeno controlado

B Evaluar al alta, a los 6 meses de edad

C Evaluar solo si presenta leucocoria

D Examen de fondo de ojo con pupila dilatada por oftalmólogo, según GES, en prematuros menores de 32 semanas o menores de 1.500 g

E Indicar vitamina A como tratamiento

Respuesta D. La retinopatía del prematuro es una vasculopatía proliferativa de la retina inmadura, favorecida por prematurez, bajo peso e hiperoxia. Es GES: se tamiza con fondo de ojo dilatado por oftalmólogo a todo prematuro menor de 1.500 g o de 32 semanas, desde las 4 semanas de vida, y se trata con láser o antiangiogénicos.

▶ VER CLASE 6.02.1.023 Retinopatía diabética

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 5.2 · Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES
Oftalmología 15.12 · Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Retinopatía diabética: microangiopatía por hiperglicemia crónica (pérdida de pericitos, isquemia, VEGF); primera causa de ceguera irreversible en edad laboral. Es asintomática hasta etapas avanzadas, por eso se busca activamente.
- Sospecha por fondo de ojo (con pupila dilatada): no proliferativa = microaneurismas (lesión más precoz), hemorragias en punto y mancha, exudados duros y algodonosos, sin neovasos; severa por regla 4-2-1; proliferativa = presencia de neovasos en papila o retina, con riesgo de hemorragia vítrea y desprendimiento traccional.
- Edema macular diabético: engrosamiento de la fóvea, puede ocurrir en cualquier etapa y es la causa más frecuente de baja visual en el diabético; se confirma con OCT y se trata con anti-VEGF intravítreo.
- Tamizaje GES retinopatía diabética: DM2 con fondo de ojo al momento del diagnóstico y luego anual; DM1 desde los 5 años del debut, luego anual. Tratamiento inicial en APS: control metabólico y de presión arterial/lípidos, notificar GES y derivar; no recetar lentes mientras la glicemia esté inestable (cambios refractivos transitorios).
- Seguimiento por oftalmología: panfotocoagulación láser en proliferativa (prioritaria, GES plazo de 60 días), anti-VEGF en edema, vitrectomía si la hemorragia no se reabsorbe; controles anual (leve) hasta cada 1–3 meses (proliferativa).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 52 años es diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 en un chequeo preventivo de salud. Se encuentra completamente asintomático desde el punto de vista visual. **¿Cuál es la indicación correcta respecto al tamizaje oftalmológico según las guías del MINSAL y la garantía GES número veintitrés?**

A Realizar fondo de ojo con pupila dilatada al momento del diagnóstico y luego anualmente

B Esperar cinco años desde el diagnóstico para realizar el primer fondo de ojo

C Solicitar fondo de ojo únicamente si la hemoglobina glicosilada supera el ocho por ciento

D Realizar fondo de ojo solo cuando el paciente refiera disminución de la agudeza visual

E Derivar a cirugía preventiva de cataratas bilateral de inmediato

Respuesta A. En la diabetes tipo 2, la enfermedad suele tener un curso subclínico de varios años antes del diagnóstico formal, así que hasta un 20 por ciento de los pacientes ya tiene algún grado de retinopatía al debut. La norma MINSAL y el GES 23 exigen fondo de ojo con pupila dilatada al momento del diagnóstico, y luego una vez al año de por vida; en la DM1, el tamizaje se inicia a los 5 años del debut.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 55 años con DM2 de 10 años de evolución, HbA1c 9 %, asintomático. En su control anual, la retinografía en APS muestra microaneurismas, exudados duros y vasos anómalos y frágiles sobre el disco óptico. Agudeza visual conservada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Optimizar el control metabólico y repetir la retinografía en 1 año

B Derivación prioritaria a oftalmología para panfotocoagulación con láser de argón

C Iniciar inyecciones intravítreas de anti-VEGF como único tratamiento

D Vitrectomía de urgencia

E Controlar solo si aparece pérdida de visión

Respuesta B. Neovasos en el disco óptico definen una retinopatía proliferativa, aunque el paciente vea bien. El tratamiento de elección es la panfotocoagulación con láser de argón (GES), que reduce el VEGF y hace regresar los neovasos. El anti-VEGF es la primera línea del edema macular central; la vitrectomía se plantea ante la hemorragia vítrea o el desprendimiento traccional.

▶ VER CLASE 6.02.1.024 Síndrome de ojo seco

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.15 · Síndrome de Sjögren y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC)

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome de ojo seco (queratoconjuntivitis seca): sensación constante de arenilla o cuerpo extraño, ardor, fotofobia, hiperemia, fatiga visual al leer o usar pantallas y lagrimeo reflejo; por déficit acuoso (Sjögren, edad, fármacos) o evaporativo (disfunción de glándulas de Meibomio, blefaritis, rosácea, uso prolongado de pantallas).
- Sospecha de Sjögren: mujer de mediana edad con xeroftalmía y xerostomía, caries cervicales, aumento de parótidas y anti-Ro/La positivos; Schirmer <5 mm en 5 minutos. El Sjögren aumenta ~40 veces el riesgo de linfoma no Hodgkin B (MALT): una parótida dura o asimétrica obliga a biopsia.
- Tratamiento inicial en APS: lágrimas artificiales sin conservantes varias veces al día, ungüento lubricante nocturno, higiene palpebral con compresas tibias, parpadeo frecuente y pausas con pantallas, humedad ambiental, y suspender fármacos que resecan (antihistamínicos, anticolinérgicos).
- Banderas rojas: dolor intenso, fotofobia, disminución de la visión o tinción corneal con fluoresceína (úlcera o queratitis): derivar. Evitar colirios con vasoconstrictor y corticoides sin control oftalmológico.
- Seguimiento: derivar a oftalmología (ciclosporina tópica, tapones lagrimales) y a reumatología si se sospecha Sjögren o enfermedad autoinmune.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 114

Paciente de 40 años con ojo rojo, sensación de arenilla, lagrimeo y fotofobia desde hace 3 meses. Usa lentes de contacto hace años. Antecedente de artritis reumatoide. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Síndrome de ojo seco (queratoconjuntivitis sicca)

B Conjuntivitis bacteriana

C Úlcera corneal por Acanthamoeba

D Escleritis

E Glaucoma agudo

Respuesta A. Los síntomas crónicos de sensación de cuerpo extraño o arenilla, lagrimeo reflejo y fotofobia en un paciente con artritis reumatoide corresponden a queratoconjuntivitis seca por síndrome de Sjögren secundario, la manifestación oftalmológica más frecuente de la enfermedad.

▶ VER CLASE 6.02.1.025 Tumores de conjuntiva

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.3 · Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumores de conjuntiva: pueden ser benignos (nevo conjuntival, papiloma, quiste de inclusión, pinguécula) o malignos (neoplasia escamosa de la superficie ocular/carcinoma espinocelular, melanoma, linfoma conjuntival «salmón»).
- Específico: lesión en conjuntiva bulbar o limbo, a veces con vasos nutricios dilatados; leucoplasia o placa gelatinosa limbar sugieren neoplasia escamosa (expuestos a UV, VIH, VPH); lesión pigmentada que crece, cambia de color o sangra sugiere melanoma; masa rosada en fornix, linfoma.
- Diferenciar de pterigion (fibrovascular triangular que invade la córnea), pinguécula y quistes; vigilar cualquier lesión que crece, se vasculariza o ulcera.
- Tratamiento inicial: no manipular ni cauterizar; fotografiar y derivar con prioridad a oftalmología para biopsia excisional con técnica «sin tocar» y estudio histológico.
- Seguimiento: derivar a oftalmología/oncología ocular; tratamiento quirúrgico con crioterapia y quimioterapia tópica (mitomicina o 5-FU); control a largo plazo por recidiva.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 65 años, agricultor, con una lesión en la conjuntiva bulbar temporal del ojo izquierdo, en el limbo, de crecimiento progresivo en 6 meses. Es gelatinosa, blanquecina, con vasos nutricios prominentes y áreas de leucoplaquia. Tiene antecedente de VIH. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Lubricantes y control anual, porque es un pterigion

B Antibiótico tópico por 7 días

C Derivar a oftalmología para biopsia excisional por sospecha de neoplasia escamosa de la superficie ocular

D Corticoide tópico

E Crioterapia en atención primaria

Respuesta C. Una lesión conjuntival limbar gelatinosa o leucoplásica, con vasos nutricios y crecimiento progresivo, en un adulto mayor con exposición solar o inmunosupresión (VIH), sugiere neoplasia escamosa de la superficie ocular (displasia a carcinoma). Se deriva para biopsia excisional. A diferencia del pterigion, no es triangular nasal ni típicamente horizontal, y crece rápido.

▶ VER CLASE 6.02.1.026 Tumores de la vía óptica

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.18 · Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

QUÉ HAY QUE SABER

- Glioma de la vía óptica (astrocitoma pilocítico): tumor de la vía óptica más frecuente en la infancia; fuerte asociación con neurofibromatosis tipo 1 (manchas café con leche, efélides axilares, neurofibromas).
- Sospecha: baja de agudeza visual progresiva, discromatopsia, defecto pupilar aferente, palidez de la papila (atrofia óptica), estrabismo, nistagmo o proptosis unilateral progresiva e indolora en un niño; puede comprometer el quiasma (defectos campimétricos, pubertad precoz, síndrome diencefálico).
- Otros: meningioma de la vaina del nervio óptico (adulto), adenoma hipofisario y craneofaringioma con hemianopsia bitemporal.
- Estudio inicial: resonancia magnética de cerebro y órbitas con gadolinio, campo visual y evaluación oftalmológica; en NF1 control oftalmológico anual en la infancia.
- Tratamiento inicial: derivar a oftalmología y neuro-oncología; observación en casos estables, quimioterapia en progresión (cirugía y radioterapia limitadas).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niña de 5 años con neurofibromatosis tipo 1 (múltiples manchas café con leche y efélides axilares). En control se detecta disminución de la agudeza visual del ojo derecho, defecto pupilar aferente relativo y palidez del disco óptico en el fondo de ojo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el estudio indicado?**

A Glioma de la vía óptica; resonancia magnética de cerebro y órbitas

B Ambliopía refractiva; lentes

C Retinoblastoma; ecografía ocular

D Neuritis óptica desmielinizante; punción lumbar

E Catarata congénita; facoemulsificación

Respuesta A. El glioma de la vía óptica (astrocitoma pilocítico) es el tumor de vía óptica más frecuente en la infancia y se asocia a NF1. Produce pérdida visual, defecto pupilar aferente, atrofia óptica, estrabismo o proptosis. Se estudia con resonancia magnética de cerebro y órbitas. En NF1 se recomienda control oftalmológico anual en la infancia.

▶ VER CLASE 6.02.1.027 Tumores de órbita

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.17 · Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumores de órbita: causa de proptosis unilateral progresiva con o sin diplopía, dolor, desplazamiento del globo y baja visual por compresión del nervio óptico. En adultos, la causa más frecuente de proptosis es la orbitopatía tiroidea; el tumor benigno más común, el hemangioma cavernoso; otros: linfoma, pseudotumor, meningioma, metástasis.
- En niños: proptosis rápidamente progresiva sin fiebre ni foco infeccioso sugiere rabdomiosarcoma (tumor maligno primario más frecuente de la órbita en la infancia); también glioma del nervio óptico, hemangioma capilar y dermoide.
- Diferenciar de celulitis orbitaria (fiebre, dolor, sinusitis, oftalmoplejía dolorosa) y de orbitopatía tiroidea (retracción palpebral, bilateral, Graves).
- Manejo inicial: TAC o RM de órbita urgente y derivación a oftalmología/oncología; biopsia por especialista; no iniciar corticoides ni antibióticos empíricos sin descartar el tumor.
- Seguimiento: derivar de inmediato ante proptosis progresiva en un niño, pérdida visual, diplopía persistente o dolor intenso.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 7 años con proptosis unilateral del ojo izquierdo de rápida progresión en 3 semanas, desplazamiento del globo hacia abajo y edema palpebral, sin fiebre, sin dolor importante y sin antecedente de sinusitis ni trauma. Hemograma y PCR normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Antibiótico endovenoso por celulitis orbitaria

B TAC o resonancia de órbitas urgente y derivación a oftalmología por sospecha de tumor orbitario maligno (rabdomiosarcoma)

C Compresas tibias y control en 1 mes

D Corticoide oral por orbitopatía tiroidea

E Antihistamínico por edema alérgico

Respuesta B. Una proptosis unilateral rápidamente progresiva en un niño, sin fiebre ni foco infeccioso, debe hacer sospechar rabdomiosarcoma, el tumor orbitario maligno primario más frecuente de la infancia. Requiere imagen urgente (TAC o RM) y biopsia. En adultos, la causa más frecuente de proptosis es la orbitopatía tiroidea y el tumor benigno más común, el hemangioma cavernoso.

▶ VER CLASE 6.02.1.028 Tumores de párpado

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.3 · Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Carcinoma basocelular: tumor maligno palpebral más frecuente (90 %), en párpado inferior y canto interno; nódulo perlado de crecimiento lento con telangiectasias, ulceración central y pérdida de pestañas (madarosis).
- Otros: carcinoma sebáceo (imita chalazión o blefaritis unilateral recidivante, en adulto mayor), espinocelular y melanoma. Sospechar ante lesión palpebral que crece en meses, que sangra, ulcerada o con madarosis, o chalazión recidivante en el mismo lugar.
- Benignos frecuentes: xantelasmas, papilomas, quistes de inclusión; derivar igual si hay duda.
- Manejo inicial: no manipular; protección solar; derivar para biopsia y exéresis con márgenes (cirugía de Mohs o reconstrucción por oculoplástica).
- Seguimiento: derivar a oftalmología/oculoplástica y control de por vida de la piel.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 112

Adulto que consulta por lesión pruriginosa de 3 meses en párpado inferior que aumentó de volumen. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Chalazión crónico

B Orzuelo interno

C Carcinoma basocelular

D Carcinoma espinocelular

E Melanoma ocular

Respuesta C. Una lesión palpebral de crecimiento lento y progresivo en un adulto, sobre todo si persiste más allá de lo esperable para un chalazión u orzuelo, obliga a descartar un carcinoma basocelular, la neoplasia maligna palpebral más frecuente por lejos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 176

Paciente de 70 años consulta por una lesión pruriginosa en el párpado inferior izquierdo, que comenzó como un pequeño nódulo hace 1 año y ha crecido progresivamente. Al examen se observa un nódulo perlado, de bordes elevados, con telangiectasias superficiales y una ulceración central, con pérdida de pestañas en la zona. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Orzuelo

B Chalazión

C Melanoma

D Carcinoma basocelular

E Conjuntivitis bacteriana crónica

Respuesta D. El carcinoma basocelular es el tumor maligno palpebral más frecuente (párpado inferior y canto interno). Se presenta como nódulo perlado con telangiectasias, ulceración central y madarosis, de crecimiento lento. Se deriva para biopsia y exéresis con márgenes. Un chalazión que recidiva o no responde en un adulto mayor también debe biopsiarse.

▶ VER CLASE 6.02.1.029 Tumores endoculares (retinoblastoma y otros)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.9 · Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Retinoblastoma: tumor intraocular maligno más frecuente de la infancia, por mutación de RB1 (germinal en formas hereditarias bilaterales, autosómica dominante); diagnóstico habitual antes de los 5 años.
- Sospecha: leucocoria (pupila blanca, reflejo rojo ausente o asimétrico, a veces visto en fotos con flash), estrabismo de aparición reciente, ojo rojo doloroso o glaucoma secundario; antecedente familiar de enucleación en la infancia. Diferencial: catarata congénita, retinopatía del prematuro, enfermedad de Coats.
- Manejo inicial en APS: el examen del rojo pupilar con oftalmoscopio es el tamizaje; leucocoria o rojo pupilar asimétrico en cualquier lactante es una urgencia de derivación. No biopsiar ni puncionar el ojo.

- Tratamiento por especialista: quimioterapia sistémica o intraarterial, terapia focal (láser, crioterapia), radioterapia o enucleación según estadio; consejo genético y tamizaje de hermanos y padres.
- Seguimiento: derivar de inmediato a oftalmología oncológica; el pronóstico depende del diagnóstico precoz (supervivencia >90 %), con vigilancia de segundos tumores en la forma hereditaria.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 83

Niño de 8 meses presenta leucocoria del ojo derecho. Como antecedente, su madre usa una prótesis ocular por una pérdida ocular en su infancia, de causa no precisada. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Retinopatía del prematuro
B Catarata congénita
C Retinoblastoma
D Glaucoma congénito
E Infección por Chlamydia trachomatis

Respuesta C. Leucocoria en un lactante, con antecedente materno de enucleación en la infancia, sugiere retinoblastoma hereditario (mutación germinal de RB1, autosómica dominante). Es el tumor intraocular maligno más frecuente en niños; se presenta con leucocoria o estrabismo. Requiere derivación urgente a oftalmología y consejo genético.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 156

Una niña de 2 años comienza con estrabismo, con desviación hacia lateral del ojo izquierdo. A la inspección ocular, se observa leucocoria izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Retinoblastoma
B Glaucoma congénito
C Catarata congénita
D Retinopatía del prematuro
E Tumor de órbita

Respuesta A. Diagnóstico: Retinoblastoma (opción A).

▶ VER CLASE 6.02.1.030 Uveítis anterior o posterior

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Oftalmología 15.1 · Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo
Reumatología 9.17 · Espondilitis Anquilosante (EA): Sacroilitis Bilateral, Columna en Caña de Bambú y Terapia Anti-TNF
Reumatología 9.20 · Enfermedad de Behçet: Aftosis Orogenital Recurrente, Fenómeno de Patergia y Panuveítis

QUÉ HAY QUE SABER

- Uveítis anterior (iritis/iridociclitis): ojo rojo con inyección ciliar (halo violáceo periquerático que no blanquea con fenilefrina), dolor moderado, fotofobia intensa con fotofobia consensual, baja de visión, miosis hiporreactiva y células en cámara anterior (fenómeno de Tyndall); la presión intraocular es normal o baja.
- Etiología: idiopática, asociada a HLA-B27 (espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, artritis reactiva, EII), artritis idiopática juvenil, sarcoidosis, Behçet (panuveítis con hipopión), infecciones (herpes, sífilis, toxoplasmosis, TBC). Uveítis posterior: visión borrosa y miodesopsias sin ojo rojo (toxoplasmosis, CMV, Behçet).
- Tratamiento inicial en APS: derivar de urgencia a oftalmología; ciclopléjico para el dolor y evitar sinequias (nunca mióticos); corticoide tópico solo tras el diagnóstico oftalmológico confirmado (nunca antes por riesgo de úlcera corneal oculta).
- Diferencial: glaucoma agudo (midriasis media fija, ojo pétreo, vómitos), queratitis (fluoresceína positiva) y conjuntivitis (secreción, sin dolor profundo ni baja visual).
- Seguimiento: derivar a oftalmología y reumatología para estudio etiológico (HLA-B27, VDRL, serologías, radiografía de tórax) y tratamiento inmunosupresor en recurrentes o crónicas.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 98

Paciente con psoriasis, disminución de agudeza visual, ojo rojo profundo y fotofobia importante. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Uveítis anterior aguda
B Epiescleritis
C Glaucoma agudo de ángulo cerrado
D Conjuntivitis bacteriana aguda
E Queratitis herpética

Respuesta A. La psoriasis es una espondiloartropatía asociada a HLA-B27, el mismo grupo de enfermedades reumatológicas que se relaciona con uveítis anterior aguda recurrente. Con ojo rojo profundo, fotofobia intensa y baja de visión, y ese antecedente reumatológico, el diagnóstico más probable es uveítis, no glaucoma ni conjuntivitis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2020 · PREGUNTA 08

¿Cuál es la manifestación extraarticular más frecuente en los pacientes con Espondilitis Anquilosante?

A Insuficiencia aórtica severa

B Uveítis anterior aguda unilateral recurrente

C Fibrosis pulmonar bibasal reticular

D Amiloidosis renal con síndrome nefrótico

E Glomerulonefritis membranosa

Respuesta B. La manifestación extraarticular más común de la Espondilitis Anquilosante es la Uveítis Anterior Aguda (iritis/iridociclitis), presente en el 25-30% de los pacientes. Es típicamente unilateral, de comienzo brusco, con dolor ocular, inyección ciliar, fotofobia y miosis, y recurre en el mismo ojo o en el contralateral sin secuelas si se trata precozmente con corticoides y midriáticos tópicos.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 31 años consulta por dolor ocular derecho, visión borrosa y fotofobia intensa de 24 horas. Como antecedentes refiere haber presentado múltiples episodios de úlceras dolorosas en la boca (4 episodios en el último año) y úlceras en el escroto que le dejaron cicatrices deprimidas. Al examen oftalmológico con lámpara de hendidura se aprecia inyección ciliar profunda y un nivel blanquecino de 1 mm de exudado leucocitario purulento en la porción inferior de la cámara anterior del ojo derecho (hipopión estéril). En las piernas presenta nódulos eritematosos dolorosos compatibles con eritema nodoso. **¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y cuál es la conducta terapéutica inmediata?**

A Enfermedad de Behçet con uveítis anterior e hipopión; hospitalizar de inmediato, indicar corticoides sistémicos a dosis altas y derivar a oftalmología para inmunosupresión con biológicos Anti-TNF

B Endoftalmitis bacteriana aguda; realizar vitrectomía anterior urgente y vancomicina intravítrea exclusiva

C Lupus eritematoso sistémico; iniciar hidroxicloroquina oral ambulatoria

D Artritis reactiva con conjuntivitis purulenta; indicar ciprofloxacino en colirio y paracetamol

E Síndrome de Sjögren descompensado; indicar lágrimas artificiales y pilocarpina oral

Respuesta A. El cuadro clínico reúne los criterios de la Enfermedad de Behçet: aftas orales recurrentes (≥ 3 al año sin cicatriz), aftas genitales escrotales que dejaron cicatriz permanente, lesiones cutáneas de eritema nodoso y una complicación oftalmológica de extrema gravedad: uveítis anterior aguda con hipopión estéril (acumulación de neutrófilos en cámara anterior). Esta manifestación ocular amenaza gravemente la visión y requiere hospitalización inmediata, pulsos de corticoides y terapia...

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años consulta por ojo izquierdo rojo y con dolor moderado de un día de evolución, con fotofobia. Al examen: inyección periquerática, agudeza visual disminuida en el ojo izquierdo, y pupila izquierda en miosis de 2 milímetros con respuesta lenta a la luz, comparada con una pupila derecha de 4 milímetros normorreactiva. La tinción con fluoresceína es negativa. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar colirio de cloranfenicol y controlar en 48 horas

B Iniciar manitol endovenoso y acetazolamida oral

C Derivar de urgencia a oftalmología para confirmar uveítis anterior

D Indicar colirio de dexametasona y control ambulatorio

E Tranquilizar a la paciente y controlar en dos semanas

Respuesta C. Inyección ciliar, dolor, fotofobia y miosis hiporreactiva unilateral son el cuadro cardinal de la uveítis anterior aguda. Con fluoresceína negativa, se descarta la queratitis. Ya hay un signo de alarma, por lo que corresponde derivar de urgencia; el corticoide solo se indica tras confirmar el diagnóstico y bajo control oftalmológico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 81

Un paciente de 30 años, con antecedente de espondilitis anquilosante consulta por ojo rojo izquierdo con dolor, desde hace 24 horas, asociado a disminución de la agudeza visual. Hace 2 años presentó un episodio similar autolimitado, por el que no había consultado. Al examen físico, se muestra lo siguiente: FOTO (Ojo examinado con la luz de hendidura que muestra discoria).

A Uveítis anterior

B Catarata

C Disgenesia pupilar

D Endoftalmitis

E Hemorragia vítrea

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Uveítis anterior). Es una uveítis anterior clásica. La celulitis orbitaria es una patología que el médico general debe saber clasificar y manejar de manera urgente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 46

Una paciente de 42 años, con antecedente de artritris psoriática e hipertensión arterial, en tratamiento farmacológico, consulta por dolor ocular izquierdo, asociado a fotofobia y disminución de la agudeza visual de dicho ojo. Al examen físico tiene ojo rojo bilateral, mayor al lado izquierdo, con marcada fotofobia en dicho lado, al examen con linterna. Su agude visual es 20/25 a derecha y 20/40 a izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Uveítis aguda
B Conjuntivitis viral
C Glaucoma agudo
D Neuritis óptica
E Glaucoma crónica

Respuesta C. Diagnóstico: Glaucoma agudo (opción C). La celulitis orbitaria es una patología que el médico general debe saber clasificar y manejar de manera urgente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 52

Un paciente de 34 años, tienen antecedente de úlceras orales a repetición y artralgias. Además, presentó una úlcera genital hace algunas semanas. Consulta por dolor en el ojo derecho, asociado a visión borrosa, de dos días de evolución. Al examen físico, se aprecia marcado enrojecimiento del ojo derecho, con agudeza visual 20/100. El diagnóstico más probable es:

A Úlcera corneal
B Trombosis de la vena central de la retina
C Conjuntivitis viral
D Uveítis
E Queratitis aguda

Respuesta D. Tiene una enfermedad de Behçet, que se asocia a uveítis, al igual que las PEA y las EII. La A, C y E no afectan la agudeza visual. La B no tiene ojo rojo.

▶ VER CLASE **6.02.1.031** **Vicios de refracción en personas de 65 años o más** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.9 · Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Presbicia y vicios de refracción en mayores de 65 años: dificultad para ver de cerca (síndrome de los brazos cortos), a veces visión borrosa de lejos por hipermetropía, miopía o astigmatismo no corregidos; sin dolor ni ojo rojo.
- Específico: agudeza visual con tabla de Snellen (lejos y cerca) y agujero estenopeico: si mejora, se confirma vicio de refracción; reflejo rojo pupilar normal hace improbable catarata. Si no mejora, derivar por catarata, maculopatía o glaucoma.
- Tratamiento inicial: sospecha GES de vicios de refracción en personas de 65 años o más (evaluación y entrega de lentes ópticos); derivar con receta para refracción y lentes; mientras tanto, buena iluminación.
- En cada evaluación descartar causas orgánicas frecuentes del adulto mayor: catarata, glaucoma crónico (fondo de ojo y tonometría), degeneración macular y retinopatía diabética.
- Seguimiento: derivar a oftalmología/optometría para refracción y entrega de lentes; control periódico de agudeza visual.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 68 años, beneficiario de FONASA, consulta en su CESFAM porque desde hace 2 años debe alejar el diario para leer y ve borroso de cerca, sin dolor ni ojo rojo. La agudeza visual de lejos es 20/30 bilateral y mejora con agujero estenopeico. El rojo pupilar es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar colirio lubricante y control en 1 año
B Derivar de urgencia por sospecha de glaucoma agudo
C Derivar con sospecha GES de vicio de refracción en mayores de 65 años para evaluación y entrega de lentes ópticos
D Solicitar resonancia magnética de cerebro
E Derivar a cirugía de catarata

Respuesta C. Dificultad para la visión cercana que se corrige alejando el texto es presbicia, y la mejoría con estenopeico confirma un vicio de refracción. Las personas de 65 años o más tienen garantía GES para el diagnóstico y la entrega de lentes ópticos. El rojo pupilar normal hace improbable una catarata significativa.

Situaciones clínicas de urgencia

10 códigos

▶ VER CLASE **6.02.2.001** **Causticaciones oculares** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.16 · Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso

QUÉ HAY QUE SABER

- Causticación ocular: única urgencia oftalmológica en que se trata antes de hacer la historia. Álcalis (soda cáustica, cal viva, cemento, amoníaco) producen necrosis por licuefacción sin barrera y penetran a cámara anterior, iris y cristalino en minutos: son los más graves. Ácidos (batería, muriático) causan necrosis por coagulación con escara que limita la penetración (excepción: ácido fluorhídrico, que actúa como álcali).

- Sospecha: contacto reciente con químico, dolor intenso, blefarospasmo, lagrimeo, ojo rojo y baja visual; la isquemia del limbo (ojo blanco sin vasos) marca el pronóstico: es necrosis, no mejoría.
- Tratamiento inicial inmediato: instilar anestésico tópico y lavar con suero fisiológico o Ringer lactato (agua corriente si no hay) 1–2 litros durante 20–30 minutos, evertir ambos párpados y barrer los fondos de saco con tórula (extraer partículas de cal o cemento); controlar con tira de pH hasta 7–7,5 y repetir a los 10 minutos.
- Errores: demorar el lavado para tomar la ficha, medir la agudeza visual o esperar al oftalmólogo; intentar neutralizar el álcali con un ácido (reacción exotérmica). No usar corticoides ni ocluir antes del lavado.
- Después del lavado: ciclopléjico, lubricación, analgesia y derivación urgente a oftalmología; complicaciones: leucoma, simbléfaron, glaucoma, necesidad de trasplante de limbo.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 173

Un paciente consulta en el servicio de urgencia porque hace 20 minutos le saltó una solución de soda cáustica en la cara, la que entró a los ojos, presentando intenso dolor y dificultades para ver. Al examen físico tiene ojo rojo profundo, córneas opacas, y con el ojo derecho solo es capaz de contar dedos, mientras que con el izquierdo tiene agudeza visual de 20/80. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Ungüento antibiótico y parche ocular

B Lavado con suero fisiológico abundante por 30 minutos

C Hielo local

D Corticoides tópicos

E Analgésicos

Respuesta B. La causticación ocular se maneja con lavado profuso con suero fisiológico o agua por 30 minutos, sin importar la agudeza visual ya perdida. Esto es distinto de la sospecha de perforación ocular, donde no se toca el ojo y solo se dan analgésicos y antibióticos endovenosos mientras se deriva con urgencia.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Trabajador de una faena de construcción, de 29 años, llega corriendo a la urgencia rural gritando de dolor, luego de que un saco de cemento y cal viva le estallara en la cara hace 10 minutos. Presenta blefarospasmo intenso y lagrimeo. El técnico de enfermería pregunta si debe tomar los signos vitales y la agudeza visual antes de ingresarlo al box. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tomar los signos vitales y la agudeza visual antes de iniciar cualquier tratamiento

B Iniciar de inmediato irrigación ocular profusa con suero fisiológico, sin esperar ningún otro trámite

C Esperar la llegada del oftalmólogo de turno antes de tocar los ojos

D Aplicar un ungüento con corticoides y ocluir con parche estéril

E Instilar un colirio con ácido acético diluido para neutralizar la cal

Respuesta B. La cal viva y el cemento son álcalis, y en toda quemadura química ocular la conducta inaplazable es la irrigación ocular inmediata y profusa. No se debe demorar el lavado por signos vitales, agudeza visual ni la llegada del especialista, y está contraindicado intentar neutralizar con otro químico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 175

Un paciente consulta en el servicio de urgencia, dado que hace 30 minutos le saltó una solución de soda cáustica caliente a la cara, la que entró a los ojos, presentando intenso dolor y dificultades para ver. Al examen físico tiene ojo rojo profundo, córneas opacas y con el ojo derecho solo es capaz de contar dedos, mientras que con el ojo izquierdo tiene agudeza visual 20/80. La conducta más adecuada es:

A Analgésicos

B Lavado con suero fisiológico abundante por 30 minutos

C Antibióticos tópicos

D Corticoides tópicos

E Parche ocular

Respuesta B. Las causticaciones oculares (con ácidos, álcalis y otros irritantes) se manejan con lavado abundante con suero fisiológico o agua, por 30 minutos y luego ATB tópicos. El parche es discutible, ya que da miedo que se adhiera el párpado al globo ocular.

▶ VER CLASE 6.02.2.002 Contusión ocular

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.15 · Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Contusión ocular (trauma cerrado): puñetazo, pelota, golpe contuso con cuadro variable: hematoma palpebral, hiposfagma, hifema, midriasis traumática, catarata, subluxación del cristalino, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina o neuropatía óptica traumática. Estudio: agudeza visual, pupilas, motilidad, fondo de ojo.
- Fractura por estallido del piso de la órbita (blow-out): diplopía al mirar hacia arriba, limitación de la elevación (atrapamiento del recto inferior), enoftalmos, equimosis periorbitaria e hipoestesia de la mejilla y labio superior (nervio infraorbitario); confirmar con TAC de órbitas.
- Descartar siempre globo abierto: pupila en gota, cámara anterior plana, Seidel positivo, hiposfagma 360° con quemosis; si hay sospecha, no presionar el ojo, no medir presión ni usar colirios o parche compresivo: concha rígida y derivar de urgencia.
- Tratamiento inicial: compresas frías, analgesia con paracetamol (sin AINE si hay hifema), reposo con cabecera elevada, aseo de heridas y profilaxis antitetánica; indicar no sonarse la nariz en sospecha de fractura orbitaria.
- Seguimiento: derivar a oftalmología (GES trauma ocular) con carácter urgente; controles de presión intraocular y fondo de ojo por desprendimiento tardío.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 35 años recibe un puñetazo en el ojo derecho hace 2 horas. Presenta equimosis y edema palpebral. Al examen: agudeza visual 20/25, diplopía al mirar hacia arriba, limitación de la elevación del ojo derecho e hipoestesia de la mejilla y el labio superior derecho. Cámara anterior sin sangre y pupilas isocóricas reactivas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Desprendimiento de retina traumático

B Fractura por estallido del piso de la órbita con atrapamiento del recto inferior

C Parálisis del tercer par craneano

D Hifema traumático

E Neuropatía óptica traumática

Respuesta B. Tras una contusión orbitaria, la diplopía con limitación de la mirada hacia arriba (atrapamiento del recto inferior) y la hipoestesia infraorbitaria (lesión del nervio infraorbitario) son típicas de la fractura por estallido del piso orbitario. Se confirma con tomografía computada de órbitas.

▶ VER CLASE 6.02.2.003 Desprendimiento de retina

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.10 · Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo

QUÉ HAY QUE SABER

- Desprendimiento de retina regmatógeno (>90 %): desgarro periférico por tracción del vítreo, con paso de vítreo licuado al espacio subretiniano. Factores: miopía magna (principal), cirugía de catarata previa, trauma. Traccional (retinopatía diabética proliferativa) y exudativo (tumor, inflamación, preeclampsia) no tienen desgarro.
- Secuencia clásica: miodesopsias bruscas (moscas volantes), fotopsias (destellos periféricos) y luego una cortina o sombra fija que avanza desde la periferia hacia el centro; caída brusca de la visión central cuando se despega la mácula. Es indoloro y el ojo está blanco.
- Sospecha en APS: fondo de ojo con retina gris, levantada y ondulada; confirmar con oftalmoscopía indirecta y pupila dilatada (el especialista). Diferenciar de hemorragia vítrea (pérdida súbita con humo rojizo, sin cortina).
- Tratamiento inicial: reposo absoluto en semi-Fowler o decúbito, régimen cero por la cirugía inminente, sin colirios, y derivación de extrema urgencia (mismo día) a un centro oftalmológico; con mácula aplicada operar en <24–48 horas (mejor pronóstico), con mácula desprendida en 7–10 días.
- Seguimiento por oftalmología: láser profiláctico si solo hay desgarro; vitrectomía pars plana o cerclaje escleral en desprendimiento establecido (GES desprendimiento de retina regmatógeno no traumático); posición boca abajo 1–2 semanas tras vitrectomía con gas.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

¿Cuál es la diferencia fisiopatológica fundamental entre el desprendimiento de retina regmatógeno y el desprendimiento de retina traccional? **¿Cuál es la diferencia fisiopatológica fundamental entre ambos?**

A El regmatógeno requiere una rotura que permite el paso de vítreo líquido; el traccional lo producen membranas fibrovasculares sin desgarro

B El regmatógeno es doloroso y con ojo rojo, mientras que el traccional es indoloro

C El traccional se opera siempre con láser superficial y el regmatógeno solo con corticoides orales

D El regmatógeno se produce por exudados inflamatorios y el traccional por hipertensión intraocular

E No existe diferencia; son dos términos sinónimos para la misma patología

Respuesta A. El desprendimiento regmatógeno exige una rotura de la retina, por la que el vítreo licuado penetra al espacio subretiniano. El traccional se origina por membranas fibróticas que tiran de la retina sin que exista una rotura inicial, típicas de la retinopatía diabética proliferativa.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 52 años con miopía de seis dioptrías consulta porque hace 48 horas comenzó a ver destellos luminosos en el rabillo del ojo derecho, como flashes de cámara, junto con muchos puntos negros flotantes. Desde esta mañana nota una sombra oscura fija en la parte inferior del campo visual derecho, que ha ido creciendo hacia el centro, como si cerraran una persiana. No refiere dolor, trauma ni ojo rojo. Al examen: ojo blanco, pupila fotorreactiva, agudeza visual conservada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar un colirio antiinflamatorio y control ambulatorio en una semana

B Reposo absoluto, régimen cero y derivación de urgencia para cirugía GES

C Tranquilizar al paciente: las moscas volantes son siempre benignas

D Solicitar una resonancia magnética de órbita antes de decidir

E Indicar reposo en el domicilio y control en un mes

Respuesta B. Fotopsias y miodesopsias agudas seguidas de una sombra en cortina que progresa, en un paciente miope y con ojo blanco indoloro, es el cuadro clásico de desprendimiento de retina regmatógeno. La agudeza visual conservada sugiere que la mácula aún está aplicada, lo que hace de esto una emergencia quirúrgica de horas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 71

Pérdida de agudeza visual en días, que alcanzaba a contar dedos y tenía defecto pupilar aferente, Entopsias y fotopsias: a. Desprendimiento de retina

A Ninguna de las anteriores es correcta

B Todas las anteriores son correctas

C No se dispone de información suficiente

D Otra alternativa no descrita

E Otra alternativa no descrita

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Ninguna de las anteriores es correcta).

▶ VER CLASE 6.02.2.004 **Disminución de la visión (lenta vs súbita)** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Oftalmología 15.8 · Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación
Oftalmología 15.10 · Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo
Oftalmología 15.11 · Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central

QUÉ HAY QUE SABER

- Disminución de la visión: primero separar lenta (semanas a años) de súbita (segundos a días), unilateral de bilateral, y dolorosa de indolora, y medir agudeza visual con estenopeico (mejora = vicio de refracción).
- Lenta e indolora: vicio de refracción y presbicia (mejoran con estenopeico), catarata (rojo pupilar atenuado, deslumbramiento nocturno, miopización), glaucoma crónico (campo en túnel, excavación >0,5), DMAE seca y retinopatía diabética.
- Súbita e indolora: oclusión de la arteria central de la retina (segundos, mancha rojo cereza, pupila de Marcus Gunn; descartar arteritis de células gigantes), oclusión venosa (hemorragias en llamarada), desprendimiento de retina (moscas, fotopsias, cortina), hemorragia vítrea (diabético, humo rojizo, pierde el rojo pupilar), DMAE húmeda (metamorfopsia, escotoma central) y neuropatía óptica isquémica o neuritis (dolor al mover el ojo).
- Súbita dolorosa con ojo rojo: glaucoma agudo, uveítis, queratitis y endoftalmitis (todas urgencias).
- Tratamiento inicial: orientar la causa, tratar lo urgente (adrenalina no, ver cada cuadro: manitol/acetazolamida/timolol en glaucoma agudo; reposo y derivación en desprendimiento; corticoides en sospecha de arteritis) y derivar a oftalmología el mismo día; controlar diabetes e hipertensión.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 74 años con catarata bilateral conocida, en lista de espera de cirugía, consulta porque hace 6 horas perdió casi por completo la visión del ojo derecho, en forma brusca y sin dolor. Hasta ayer veía con dificultad, pero en forma estable. Agudeza visual: cuenta dedos a 1 metro en el ojo derecho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Atribuirlo a progresión de la catarata y mantener la espera habitual

B Adelantar la cirugía de catarata en forma electiva

C Indicar lentes nuevos y control en 3 meses

D Derivar a oftalmología de urgencia el mismo día

E Colirio lubricante y control en 1 semana

Respuesta D. La catarata produce pérdida visual lenta y progresiva en meses o años, nunca en horas. Una disminución súbita e indolora obliga a buscar otra causa, como oclusión arterial o venosa retiniana, hemorragia vítrea o desprendimiento de retina, y requiere evaluación oftalmológica urgente.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 70 años, fumador, consulta porque hace 4 días nota en el ojo derecho que las líneas rectas, como los marcos de las puertas, se ven onduladas, y una mancha oscura en el centro de la visión. No tiene dolor ni ojo rojo. Agudeza visual 20/100 en el ojo derecho, que no mejora con agujero estenopeico. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Catarata senil

B Glaucoma crónico

C Degeneración macular relacionada con la edad neovascular

D Vicio de refracción

E Conjuntivitis viral

Respuesta C. Metamorfopsia y escotoma central de instalación en días, en un adulto mayor fumador, sugieren degeneración macular neovascular, o húmeda. Es una pérdida visual subaguda que requiere derivación urgente a oftalmología para terapia antiangiogénica intravítrea. La catarata y el glaucoma crónico producen pérdida lenta y sin metamorfopsia.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 71 años, hipertenso, con fibrilación auricular en tratamiento irregular, consulta por pérdida visual súbita y completa del ojo izquierdo, iniciada hace 2 horas al despertar. Refiere que se apagó la luz de golpe en ese ojo, sin dolor ni traumatismo. Al examen: ojo blanco, agudeza visual limitada a percepción de luz, defecto pupilar aferente en el ojo izquierdo. El fondo de ojo muestra palidez retiniana difusa con un punto rojo brillante en la fóvea. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar reposo domiciliario y control ambulatorio en una semana

B Iniciar maniobras de rescate ocular, derivar de urgencia y estudiar fuente embólica

C Indicar colirio de corticoide y antiinflamatorio oral

D Tranquilizar al paciente: la fibrilación auricular no se relaciona con la visión

E Solicitar campo visual computarizado antes de decidir cualquier conducta

Respuesta B. Pérdida monocular súbita, catastrófica e indolora, con defecto pupilar aferente y mancha rojo cereza foveal, en un paciente con fibrilación auricular: oclusión de la arteria central de la retina de origen cardioembólico. La conducta es intentar maniobras de rescate, derivar de urgencia y hospitalizar para estudio vascular y anticoagulación, previniendo un accidente cerebrovascular futuro.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 55 años, hipertensa, presenta disminución progresiva de la visión de su ojo izquierdo en las últimas 24 horas. Al fondo de ojo se observan hemorragias retinianas masivas en llama en los cuatro cuadrantes, venas tortuosas muy dilatadas y exudados algodonosos. Tres meses después consulta por dolor ocular insoportable y ojo rojo intenso, con la presión intraocular muy elevada. **¿Qué complicación ha desarrollado?**

A Glaucoma agudo por cierre angular primario

B Glaucoma neovascular secundario a la isquemia retiniana

C Endoftalmitis endógena bacteriana

D Desprendimiento de retina exudativo

E Uveítis anterior hipertensiva

Respuesta B. El cuadro inicial es una oclusión de la vena central de la retina de tipo isquémica. La falta de perfusión estimula la liberación masiva de VEGF, que produce neovasos en el iris y el ángulo, bloqueando la malla trabecular: es el glaucoma neovascular, o glaucoma de los cien días, que aparece típicamente a los tres meses.

▶ VER CLASE 6.02.2.005 Glaucoma agudo

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Oftalmología 15.1 · Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo
Oftalmología 15.6 · Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida

QUÉ HAY QUE SABER

- Glaucoma agudo de ángulo cerrado: ojo pequeño hipermétrope con cámara anterior estrecha, edad avanzada/catarata; gatillado por midriasis media (penumbra, estrés, anticolinérgicos, topiramato). Bloqueo pupilar: PIO sube a 50–80 mmHg.
- Sospecha: cefalea unilateral brutal con náuseas y vómitos (se confunde con migraña o ACV), baja brusca de visión y halos de colores; ojo rojo con inyección ciliar, córnea en vidrio esmerilado, pupila en midriasis media fija y arreactiva, y ojo pétreo a la palpación comparado con el otro.
- Tratamiento inicial en urgencia: bajar la PIO de inmediato con manitol EV, acetazolamida oral o EV y timolol tópico, más corticoide tópico (prednisolona) para la inflamación; analgesia y antieméticos; pilocarpina solo cuando la presión ya haya bajado (con PIO muy alta el esfínter está isquémico). Derivar urgente.
- Contraindicado: midriáticos (atropina, tropicamida) en ángulo estrecho no tratado, que agravan el bloqueo y pueden dejar ciego. Diferenciar de uveítis anterior (miosis, PIO normal o baja, sin vómitos).
- Tratamiento definitivo por oftalmología: iridotomía periférica láser YAG siempre en ambos ojos (el ojo sano tiene 50–70 % de riesgo de crisis).

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 80

Una paciente de 54 años, con antecedente de jaqueca, que trata profilácticamente con topiramato. Refiere estar con más estrés del habitual. Hace dos horas comienza con cefalea intensa, de localización periocular derecha, asociada a náuseas y vómitos. Al examen físico se aprecia el ojo izquierdo enrojecido, con la pupila fija, en semimidriasis. **La conducta inicial más adecuada es:**

A Manitol endovenoso

B Clorpromazina endovenosa

C Ketorolaco endovenoso

D Oxígeno al 100% más eletriptán subcutáneo

E Carbamazepina oral

Respuesta A. Una migrañosa en profilaxis con topiramato, con dolor periocular, náuseas, ojo rojo y pupila fija en semimidriasis: glaucoma agudo de ángulo cerrado, un efecto adverso conocido del topiramato. Se trata con manitol endovenoso, mióticos e iridotomía. Tratarla como crisis de migraña es la trampa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 149

Un paciente de 48 años, con antecedente de hipermetropía, consulta por dolor en el ojo izquierdo, muy intenso, irradiado a la frente. Al examen físico, se aprecia eritema periquerático del ojo izquierdo, con pupila midriática arreactiva y se aprecia opacidad corneal. El ojo derecho tiene visión 20/20, mientras que el ojo izquierdo tiene visión borrosa, que solo es capaz de contar dedos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Conjuntivitis
B Uveítis aguda
C Queratitis viral aguda
D Trombosis de la vena central de la retina
E Glaucoma agudo

Respuesta E. Hipermetropía como factor de riesgo, dolor intenso irradiado a la frente, eritema periquerático, pupila midriática arreactiva, opacidad corneal y caída severa de la agudeza visual son el cuadro clásico del glaucoma agudo de ángulo cerrado. La hipermetropía predispone porque el ojo es más pequeño y el ángulo, más estrecho.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 3

Un paciente de 30 años, hipermétrope, consulta por cefalea intensa, en el lado derecho, asociado a náuseas, de intensidad 10/10. Al examen físico se observa ojo rojo profundo en el lado derecho, con pupila en midriasis fija y arreactiva. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Glaucoma agudo
B Trombosis de la vena central de la retina
C Cefalea cluster
D Celulitis orbitaria
E Accidente vascular encefálico

Respuesta A. Hipermétrope con cefalea unilateral intensa, náuseas, ojo rojo profundo y midriasis fija arreactiva: glaucoma agudo de ángulo cerrado, el diagnóstico que hay que descartar antes de pensar en una causa neurológica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 144

Una paciente de 50 años consulta por dolor ocular izquierdo de inicio agudo, asociado a visión borrosa. Al examen físico destaca ojo rojo periquerático y pupila midriática arreactiva; la agudeza visual está disminuida en el ojo izquierdo respecto al derecho. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Uveítis aguda
B Endoftalmitis
C Queratitis aguda
D Escleritis
E Glaucoma agudo

Respuesta E. Dolor agudo, visión borrosa, ojo rojo periquerático y midriasis arreactiva: glaucoma agudo. La midriasis fija lo distingue de la uveítis, que da miosis; ni la escleritis ni la queratitis producen ese cambio pupilar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 80

Una paciente de 54 años, con antecedente de jaqueca, tratada profilácticamente con topiramato, refiere estar con más estrés del habitual. Hace 2 horas comienza con cefalea intensa, periocular derecha, asociada a náuseas y vómitos. Al examen físico se aprecia el ojo derecho enrojecido, con la pupila fija, en semimidriasis. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Manitol endovenoso
B Clorpromazina endovenosa
C Ketorolaco endovenoso
D Oxígeno al 100% más eletriptán subcutáneo
E Carbamazepina oral

Respuesta A. El topiramato puede precipitar un glaucoma agudo de ángulo cerrado bilateral por efecto anticolinérgico e inflamación ciliar; el cuadro clínico, con pupila fija en semimidriasis, lo confirma. La conducta inicial es manitol endovenoso, dentro de la tríada hipotensora.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años, hipermétrope, consulta a las 23 horas por dolor ocular derecho intolerable, iniciado hace 4 horas mientras veía una película en el cine. El dolor le irradia a la frente y se acompaña de náuseas y 2 vómitos. Al examen: córnea derecha turbia y sin brillo, pupila derecha en midriasis media fija, y el ojo derecho se palpa notablemente más duro que el izquierdo. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Colirio de atropina al 1% y corticoide tópico
B Manitol endovenoso, acetazolamida oral y timolol tópico
C Analgésicos orales y control ambulatorio en 48 horas
D Pilocarpina tópica en dosis repetidas cada 5 minutos
E Tomografía computarizada de cerebro de urgencia

Respuesta B. Hipermétrope, dolor tras estar en penumbra, midriasis media fija y ojo pétreo: glaucoma agudo de ángulo cerrado. El manejo inicial es manitol endovenoso, acetazolamida y timolol tópico. La atropina agravaría el bloqueo, y la pilocarpina sola no funciona con la presión tan alta.

▶ VER CLASE **6.02.2.006** **Hemorragia vítrea** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.12 · Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemorragia vítrea: sangre en el vítreo, causa más frecuente de pérdida súbita e indolora de visión en el diabético (neovasos de la retinopatía proliferativa); otras causas: desgarro retiniano, oclusión venosa, trauma y degeneración macular neovascular.
- Sospecha: pérdida brusca de visión con «humo», telarañas o tinte rojizo, moscas volantes; ojo blanco y sin dolor; rojo pupilar disminuido o ausente, con agudeza visual desde cuenta dedos a movimiento de manos. Diferenciar del desprendimiento de retina (cortina que avanza con fotopsias previas).
- Tratamiento inicial en APS: derivar a oftalmología con carácter urgente; reposo con la cabeza elevada (permite que la sangre decante), suspender antiagregantes/anticoagulantes cuando sea posible y controlar la glicemia; no dar colirios.
- Estudio por especialista: ecografía ocular modo B (para descartar desprendimiento o desgarro asociado, ya que no se ve el fondo), fotocoagulación láser, anti-VEGF o vitrectomía si no se reabsorbe.
- Seguimiento: derivar a oftalmología; control metabólico estricto y fondo de ojo anual de por vida en diabéticos.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 177

Un paciente de 68 años, diabético e hipertenso presenta disminución brusca de la visión del ojo izquierdo, que solo le permite diferenciar los movimientos de una mano, sin poder identificar letras. La agudeza visual del ojo derecho es normal. La exploración externa es normal y el rojo pupilar es negativo en ese ojo. En sus exámenes destaca hemoglobina glicosilada de 9,2%. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Neuritis óptica isquémica
B Desprendimiento de retina
C Hemorragia vítrea
D Trombosis de la arteria central
E Edema macular

Respuesta C. Diabético mal controlado con pérdida visual brusca e indolora y rojo pupilar negativo: hemorragia vítrea por rotura de neovasos de una retinopatía proliferativa. La pérdida del rojo pupilar es el signo que la distingue.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 157

Una paciente de 56 años, diabética de larga data, mal controlada, con nefropatía diabética en etapa IV, presenta pérdida súbita e indolora de la visión del ojo izquierdo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Glaucoma
B Edema macular
C Uveítis
D Trombosis de la vena central de la retina
E Hemorragia vítrea

Respuesta E. La nefropatía avanzada indica daño microvascular extenso y sugiere una retinopatía proliferativa, que se complica con hemorragia vítrea: pérdida súbita e indolora. Al examen se perdería el rojo pupilar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 157

Una paciente de 56 años, diabética de larga data y mal controlada, con nefropatía diabética en etapa 4, presenta pérdida súbita e indolora de la visión del ojo izquierdo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Glaucoma
B Edema macular
C Uveítis
D Trombosis de la vena central de la retina
E Hemorragia vítrea

Respuesta E. El antecedente de diabetes de larga data con daño renal avanzado sugiere una microangiopatía sistémica severa, compatible con una retinopatía diabética proliferativa ya complicada con hemorragia vítrea, la causa más frecuente de pérdida súbita e indolora de la visión en el diabético de larga data.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 177

Un paciente de 68 años, diabético e hipertenso, presenta disminución brusca de la visión del ojo izquierdo, que solo le permite diferenciar los movimientos de una mano, sin poder identificar letras. La exploración externa es normal y el rojo pupilar es negativo en ese ojo. En sus exámenes destaca una hemoglobina glicosilada de nueve coma dos por ciento. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Neuritis óptica isquémica
B Desprendimiento de retina
C Hemorragia vítrea
D Trombosis de la arteria central de la retina
E Edema macular

Respuesta C. La pérdida súbita de visión reducida a percepción de movimientos de mano, con pérdida del reflejo rojo pupilar y una hemoglobina glicosilada muy elevada, es una hemorragia vítrea. El edema macular tarda días en instalarse y no borra el rojo pupilar; la oclusión arterial da mancha rojo cereza, no pérdida del rojo pupilar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 179

Paciente de 60 años, diabético e hipertenso mal controlado, consulta por pérdida súbita e indolora de la visión del ojo izquierdo. Con ese ojo solo cuenta dedos. No hay alteraciones externas, pero el rojo pupilar del ojo izquierdo está muy disminuido. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trombosis de la vena central de la retina

B Desprendimiento de retina

C Neuritis óptica

D Embolia de arteria central de la retina

E Hemorragia vítrea

Respuesta E. Pérdida visual súbita e indolora con rojo pupilar disminuido (sangre en el vítreo que impide ver el fondo) en un diabético mal controlado es hemorragia vítrea por retinopatía diabética proliferativa. Se deriva a oftalmología: ecografía ocular para descartar desprendimiento de retina, y fotocoagulación láser, antiangiogénicos o vitrectomía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 91

Un paciente de 68 años, diabético de larga data, fumador, presenta pérdida brusca de la visión del ojo derecho, sin dolor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Infarto occipital

B Desprendimiento de retina

C Hemorragia vítrea

D Degeneración macular

E Edema macular

Respuesta C. Es una HV clásica, que es la causa de ceguera en la retinopatía diabética. La pérdida de rojo pupilar es un signo característico, aunque no se mencione. El infarto occipital daría hemianopsia homónima contralateral. El DR sí pierde la visión, pero suele ser como una caída de telón o levantamiento de pared y estar precedido de fotopsias y entopsias. La DMRE es crónica y la AV disminuye lentamente. El edema macular sí puede producir ceguera, pero demora varios días en instalarse.

▶ VER CLASE 6.02.2.007 Herida penetrante o perforante ocular

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.15 · Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Herida penetrante o perforante ocular (trauma abierto): herida de espesor total de córnea o esclera por objeto cortante (clavo, vidrio, balín) o cuerpo extraño de alta velocidad (martillar metal sin protección); perforante si tiene orificio de salida; ruptura por objeto romo.
- Signos de sospecha: pupila en gota que apunta a la herida, cámara anterior plana o anormal, hipotonía, signo de Seidel positivo, protrusión de iris/coroides/vítreo, hiposfagma masivo en 360° con quemosis tras trauma contuso; baja de visión.
- Tratamiento inicial (GES trauma ocular grave): proteger con concha rígida fenestrada apoyada en el reborde óseo, sin comprimir el globo; régimen cero, cabecera a 30°, analgesia y antieméticos EV (evitar vómito/Valsalva), antibiótico EV (ceftazidima + vancomicina) y profilaxis antitetánica; derivar de urgencia a pabellón.
- Prohibido: palpar el ojo, medir la presión (tonometría), aplicar pomadas o colirios, parche compresivo; la resonancia magnética está contraindicada si se sospecha cuerpo extraño metálico: el examen de elección es TAC de órbita sin contraste con cortes finos.
- Seguimiento: derivar de inmediato a oftalmología para reparación quirúrgica; riesgo de endoftalmitis, desprendimiento de retina y oftalmía simpática.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un obrero de la construcción acude a un centro de urgencias tras recibir el impacto de un clavo en el ojo izquierdo. Al examen físico el paciente se encuentra muy quejumbroso, la agudeza visual en el ojo izquierdo es de bultos a 30 cm, la pupila está desfigurada en forma de pera apuntando hacia la hora 2, y se observa una cámara anterior muy plana con salida de un filamento negruzco a través de una incisión en la córnea. **¿Cuál de las siguientes conductas representa una acción estrictamente contraindicada en este paciente?**

A Instalar una concha o protector rígido fenestrado plástico fijado con tela adhesiva

B Administrar analgesia y antieméticos por vía endovenosa

C Realizar tonometría aplanática para cuantificar el grado de hipotonía ocular

D Indicar ayuno absoluto y solicitar evaluación urgente por oftalmología

E Administrar vacuna antitetánica si no tiene dosis de refuerzo reciente

Respuesta C. Ante signos inequívocos de globo ocular abierto (pupila en gota con herniación de tejido uveal y atalamia), medir la presión intraocular está estrictamente contraindicado: el contacto del tonómetro presiona el ojo y puede expulsar el contenido intraocular. La protección con concha rígida, la analgesia y antieméticos EV, y el ayuno son conductas mandatorias.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Adolescente de 16 años recibe el impacto de un balín de un rifle de aire comprimido en el ojo derecho mientras jugaba con un amigo. Consulta de inmediato por dolor y visión borrosa. Al examen: agudeza visual cuenta dedos a 2 metros, una laceración de 3 mm en la córnea periférica, cámara anterior colapsada y pupila deformada en forma de gota que apunta hacia la laceración. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Medir la presión intraocular con tonómetro de aplanación para cuantificar la hipotonía

B Aplicar un parche ocular compresivo firme y colirio antibiótico de amplio espectro

C Proteger el ojo con una concha rígida apoyada en el reborde óseo, régimen cero, analgesia y antieméticos endovenosos, y derivar de urgencia

D Indicar reposo domiciliario con colirio ciclopléjico y control ambulatorio en 48 horas

E Realizar irrigación ocular profusa con suero fisiológico durante 30 minutos

Respuesta C. La pupila en gota apuntando hacia la laceración y la cámara anterior colapsada son signos de sospecha fundada de globo ocular abierto. La conducta es proteger sin comprimir con una concha rígida, régimen cero, analgesia y antieméticos endovenosos, y derivar de urgencia bajo GES 48; están prohibidas la tonometría, las pomadas, los colirios y el parche compresivo.

▶ VER CLASE 6.02.2.008 Heridas de párpados

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.15 · Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Heridas de párpados: laceraciones, mordeduras de perro o cortes; siempre descartar lesión del globo ocular (agudeza visual, pupila, fluoresceína, rojo pupilar) antes de suturar.
- Específico: reconocer heridas de espesor completo, que comprometen el borde libre o el tarso, y las mediales al punto lagrimal (riesgo de sección del canalículo y epífora crónica) o con lesión del elevador (ptosis).
- Tratamiento inicial: aseo con suero, hemostasia suave, analgesia, profilaxis antitetánica y, en mordeduras, antibiótico (amoxicilina-clavulánico) y evaluación de profilaxis antirrábica; cubrir con gasa húmeda sin comprimir si se sospecha globo abierto.
- Heridas superficiales y limpias fuera del borde pueden ser suturadas por el médico entrenado; las de espesor completo, del borde palpebral o de la vía lagrimal se derivan a oftalmología para reparación en 24–48 horas para evitar deformidades.
- Seguimiento: derivar a oftalmología/oculoplástica; control de cicatrización, retiro de puntos a los 5–7 días en la cara y vigilancia de epífora.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 6 años sufre mordedura de perro en la cara. Tiene una herida de espesor completo en el tercio medial del párpado inferior derecho, entre el punto lagrimal y el canto interno. El globo ocular parece indemne. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Sutura simple de piel en el servicio de urgencia

B Parche ocular compresivo y control en 1 semana

C Dejar cicatrizar por segunda intención

D Cierre con adhesivo tisular

E Aseo, profilaxis antibiótica y antirrábica según corresponda, y derivación a oftalmología para reparación con evaluación y reconstrucción de la vía lagrimal (canalículo)

Respuesta E. Las heridas palpebrales mediales al punto lagrimal pueden seccionar el canalículo, y las que comprometen el borde libre o son de espesor completo requieren reparación por especialista para evitar epífora crónica y deformidades. Ante una herida palpebral siempre se descarta lesión del globo. Las mordeduras requieren además aseo, antibiótico (amoxicilina-clavulánico) y evaluación de profilaxis antirrábica y antitetánica.

▶ VER CLASE 6.02.2.009 Parálisis III par + midriasis

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.4 · Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino

QUÉ HAY QUE SABER

- Parálisis del III par con midriasis: ptosis completa, ojo desviado hacia abajo y afuera (diplopía) y pupila dilatada, fija y arreactiva a la luz directa y consensual (lesión eferente); si se acompaña de cefalea intensa, es compresión por aneurisma de la arteria comunicante posterior hasta demostrar lo contrario.
- Específico: una paresia aislada del III par con pupila comprometida es compresiva (aneurisma, tumor, uncus en hipertensión endocraneana); la isquémica microvascular (diabetes, HTA) respeta la pupila (pupila normal). Diferenciar del defecto aferente (la pupila sí se contrae con la luz del ojo sano) y del síndrome de Horner.
- Tratamiento inicial: emergencia: TAC sin contraste y angio-TAC cerebral urgentes (descartar hemorragia subaracnoidea y aneurisma), control neurológico y de presión arterial, y derivación inmediata a centro con neurocirugía.
- En hemorragia subaracnoidea: reposo, analgesia, nimodipino, PA sistólica <160 mmHg hasta asegurar el aneurisma (coils o clipaje en 24–72 horas).
- Seguimiento: derivar a neurología/neurocirugía; no esperar la evolución ni dar alta con cefalea y midriasis fija.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 48 años consulta por cefalea intensa retroocular derecha de 1 día y visión doble. Al examen tiene ptosis palpebral derecha, ojo desviado hacia abajo y afuera y pupila derecha midriática arrefléctica. Sin rigidez de nuca. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Diagnosticar parálisis microvascular del III par y controlar en 3 meses

B Angio-TAC o angiorresonancia cerebral urgente por sospecha de aneurisma de la arteria comunicante posterior

C Iniciar corticoides por neuritis

D Indicar parche ocular y control con oftalmología

E Prueba de hielo para miastenia

Respuesta B. Una parálisis del III par con midriasis (compromiso pupilar) y cefalea sugiere compresión de las fibras parasimpáticas periféricas por un aneurisma de la comunicante posterior, con riesgo de rotura: requiere angio-TAC o angiorresonancia urgente. La parálisis microvascular (diabetes, HTA) típicamente respeta la pupila. La miastenia nunca compromete la pupila.

▶ VER CLASE 6.02.2.010 **Úlcera corneal** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.4 · Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)

QUÉ HAY QUE SABER

- Úlcera corneal: defecto epitelial con infiltrado del estroma; ojo rojo con inyección ciliar, dolor intenso, fotofobia, blefarospasmo, lagrimeo y baja de agudeza visual; infiltrado blanquecino con fluoresceína positiva y, en graves, hipopión.
- Específico: factor de riesgo clave es el uso de lentes de contacto blandos (dormir con ellos, higiene con agua); también trauma, cuerpo extraño y herpes (dendrita). Confirmar con fluoresceína bajo luz azul de cobalto; no usar anestésico tópico repetido.
- Tratamiento inicial: retirar el lente y guardarlo para cultivo, colirio antibiótico de amplio espectro (fluoroquinolona; reforzados vancomicina + ceftazidima en el centro especializado), ciclopléjico para el dolor y analgesia oral; no ocluir con parche. Herpética: aciclovir tópico.
- JAMÁS corticoides tópicos en úlcera sin diagnóstico oftalmológico (perforación). Complicaciones: perforación, endoftalmitis y leucoma.
- Seguimiento: derivar de urgencia (mismo día) a oftalmología para raspado, cultivo y tratamiento reforzado; control cada 24 horas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 107

Una paciente miope, usuaria de lentes de contacto blando, consulta por dolor ocular izquierdo, asociado a epífora. Al examen muestra ojo rojo periquerático en el ojo izquierdo, con lagrimeo y una zona de opacidad corneal de 2,1 milímetros de diámetro. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Conjuntivitis bacteriana

B Úlcera corneal

C Uveítis aguda

D Glaucoma agudo

E Blefaritis

Respuesta B. Usuaria de lentes de contacto con dolor ocular, inyección periquerática y una zona de opacidad corneal focal es una úlcera corneal, el diagnóstico que hay que sospechar siempre en portadores de lentes con ojo rojo doloroso. La conjuntivitis no da opacidad corneal ni dolor real; la uveítis y el glaucoma no explican la opacidad focal de la córnea.

Conocimientos generales

6 códigos

▶ VER CLASE 6.02.3.001 **Accidentes del trabajo**

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.15 · Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Los traumatismos oculares laborales (esmeril, soldadura, martillar metal, químicos, proyección de partículas) son accidentes del trabajo según la Ley 16.744: se emite la Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) y se deriva al organismo administrador (mutual o ISL), que cubre atención, licencia y prestaciones.
- Prevención: uso obligatorio de elementos de protección personal (lentes, antiparras o careta) provistos por el empleador, estación lavaojos en lugares con químicos, capacitación y fiscalización.
- Cuerpo extraño superficial: extraer, antibiótico tópico y control; si hubo alta velocidad (martillar metal) sospechar cuerpo extraño intraocular y pedir TAC de órbita (nunca resonancia); en causticación irrigar abundantemente de inmediato.
- Soldadores: queratitis actínica (dolor bilateral horas después de la exposición, cura en 24–48 horas con lubricantes); no entregar anestésico tópico para uso repetido.
- Derivar a oftalmología los casos con baja de visión, herida penetrante, causticación o cuerpo extraño no removible; el seguimiento y la rehabilitación quedan a cargo del organismo administrador.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 35 años, trabajador de una maestranza, consulta en urgencia por sensación de cuerpo extraño en el ojo derecho tras usar un esmeril sin lentes de protección hace 3 horas. Al examen hay un cuerpo extraño metálico superficial en la córnea con anillo de óxido incipiente. **Además del manejo del cuerpo extraño, ¿cuál es la conducta administrativa y preventiva correcta?**

A Considerarlo accidente del trabajo: emitir la Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) y derivar a su organismo administrador (mutual o ISL); reforzar el uso obligatorio de protección ocular

B Licencia por enfermedad común con cargo a su previsión de salud

C No requiere notificación porque es una lesión leve

D Derivar a COMPIN para calificar enfermedad profesional

E Recomendar al trabajador cambiar de oficio

Respuesta A. Las lesiones oculares por esmeril, soldadura o químicos en el trabajo son accidentes del trabajo (Ley 16.744): se emite la DIAT y la atención, licencia y prestaciones son de cargo del organismo administrador. Son prevenibles con elementos de protección personal (lentes o careta), que el empleador debe proporcionar. Con radiografía se descarta cuerpo extraño intraocular si hubo alta velocidad.

▶ VER CLASE 6.02.3.002 Diabetes

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.12 · Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Diabetes y ojo: la retinopatía diabética es asintomática hasta etapas avanzadas, por lo que el tamizaje es la medida preventiva clave; además la diabetes acelera la catarata y aumenta glaucoma, oclusiones vasculares y neuropatías ópticas.
- Tamizaje GES: DM2 con fondo de ojo con pupila dilatada (o retinografía) al diagnóstico y luego anual de por vida; DM1 a los 5 años del debut y luego anual; en embarazadas diabéticas, control por trimestre.
- Visión borrosa fluctuante en hiperglicemia: cambio refractivo transitorio por hidratación del cristalino, mejora con estenopeico; no recetar lentes hasta estabilizar la glicemia.
- Prevención: control estricto de glicemia (HbA1c), presión arterial y lípidos; suspender tabaco; educar en síntomas de alarma (moscas volantes, sombra, pérdida súbita de visión).
- Derivar a oftalmología: cualquier grado de retinopatía, edema macular, baja de visión no explicada o fondo de ojo no valorable (catarata, hemorragia).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 50 años, recién diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 con glicemia de 380 mg/dL, consulta por visión borrosa bilateral fluctuante de 3 semanas, sin dolor ni ojo rojo. La agudeza visual mejora con agujero estenopeico y el fondo de ojo con dilatación pupilar es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a su visión?**

A Recetar lentes ópticos de inmediato con la refracción actual

B Solicitar angiografía con fluoresceína

C Derivar de urgencia por sospecha de retinopatía proliferativa

D Iniciar fotocoagulación láser preventiva

E Lograr el control glicémico y diferir la receta de lentes hasta que la glicemia se estabilice, manteniendo el fondo de ojo anual

Respuesta E. La hiperglicemia cambia la hidratación del cristalino y produce cambios refractivos transitorios y fluctuantes, que mejoran con estenopeico. No se deben recetar lentes hasta estabilizar la glicemia, porque la refracción volverá a cambiar. Con fondo de ojo normal, corresponde control anual de por vida.

▶ VER CLASE 6.02.3.003 Examen visual en adulto

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.9 · Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen visual en el adulto: medir agudeza visual lejana (Snellen a 6 m) y cercana, con y sin corrección, monocular, y con agujero estenopeico si está disminuida; examinar rojo pupilar y reflejos pupilares.
- Desde los 40 años pesquisar presbicia, glaucoma crónico (tonometría y fondo de ojo: excavación >0,5, asimetría >0,2), catarata y degeneración macular; anamnesis de antecedentes familiares de glaucoma, diabetes e hipertensión.
- Presbicia desde los 40–45 años: se corrige con lentes positivos para cerca; dificultad de lejos que mejora con estenopeico indica vicio de refracción.
- Población de riesgo con control periódico: diabéticos (fondo de ojo anual), hipertensos, familiares de glaucoma, miopes altos y trabajadores con riesgo ocular.
- Derivar a oftalmología si hay baja de agudeza visual no corregible, excavación sospechosa, PIO elevada, rojo pupilar alterado o síntomas de alarma (fotopsias, escotomas, dolor).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 45 años, sin antecedentes, consulta porque desde hace unos meses debe alejar el celular y los textos para poder leer, especialmente con poca luz. La agudeza visual de lejos es 20/20 en ambos ojos, el segmento anterior es normal y la presión intraocular es normal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?**

A Catarata; cirugía

B Degeneración macular; antiangiogénicos

C Miopía; lentes negativos

D Glaucoma crónico; colirios hipotensores

E Presbicia; corrección con lentes positivos (convergentes) para visión cercana

Respuesta E. La presbicia es la pérdida de acomodación del cristalino con la edad; desde los 40 a 45 años dificulta la visión cercana y obliga a alejar el texto. Se corrige con lentes positivos para lectura. El examen visual del adulto incluye agudeza visual lejana y cercana y, desde los 40 años, presión intraocular y fondo de ojo.

▶ VER CLASE 6.02.3.004 Examen visual preventivo en niños

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.9 · Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizaje visual del niño: examen del rojo pupilar con oftalmoscopio en el recién nacido y en cada control; reflejo corneal (Hirschberg) y cover test desde los primeros meses; agudeza visual con optotipos desde los 3–4 años (control sano a los 4 años en Chile).
- Derivar si hay leucocoria, rojo pupilar ausente o asimétrico, estrabismo constante o que persiste después de los 6 meses, agudeza visual peor de la esperada para la edad o diferencia ≥2 líneas entre ambos ojos, nistagmo o antecedentes de prematurez/retinopatía.
- Objetivo: detectar ambliopía y estrabismo dentro de la ventana de plasticidad visual (hasta los 7–8 años); después es irreversible. Tratamiento: corrección óptica y parche en el ojo sano (GES estrabismo en menores de 9 años).
- Pesquisa en prematuros: tamizaje de retinopatía del prematuro con fondo de ojo (<1.500 g o <32 semanas).
- Medidas de población: control sano anual, uso de pantallas con moderación y tiempo al aire libre; derivar a oftalmología ante cualquier duda.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En el control de salud de un niño de 4 años, sano, se realiza tamizaje de agudeza visual con cartilla adecuada a su edad. Obtiene 20/40 en el ojo derecho y 20/20 en el izquierdo. El rojo pupilar es simétrico y el test de Hirschberg es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tranquilizar: a esta edad es normal una diferencia de dos líneas entre ambos ojos

B Repetir el tamizaje en 2 años, al ingreso escolar

C Solicitar resonancia magnética de órbitas

D Indicar parche en el ojo izquierdo sin evaluación previa

E Derivar a oftalmología para evaluación de ambliopía y vicio de refracción

Respuesta E. En el tamizaje preescolar se deriva si la agudeza es peor de lo esperado para la edad o si hay una diferencia de 2 líneas o más entre ambos ojos, porque sugiere ambliopía por anisometropía. La ambliopía solo es tratable en la ventana de plasticidad visual, por lo que no se debe esperar.

▶ VER CLASE 6.02.3.005 Hipertensión arterial

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.13 · Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar

QUÉ HAY QUE SABER

- Retinopatía hipertensiva: la retina permite ver el daño microvascular de la HTA; fases vasoconstrictora, esclerótica (hilo de cobre, luego de plata) y exudativa. Clasificación de Keith-Wagener-Barker: I estrechamiento arteriolar («hilo de cobre»); II cruces AV patológicos (signos de Gunn y Salus); III hemorragias en llama y exudados algodonosos; IV todo lo anterior más edema de papila bilateral.
- El grado IV define la emergencia hipertensiva maligna (PA habitualmente >200/120, encefalopatía, falla renal): hospitalizar en UCI con labetalol o nitroprusiato EV en infusión continua; bajar la presión arterial media solo 20–25 % en las primeras 2–4 horas, nunca de golpe (ni nifedipino sublingual).
- Grados I–II: ajuste del antihipertensivo oral en APS; grado III: urgencia hipertensiva con ajuste farmacológico rápido y control estrecho, sin necesariamente UCI.
- Complicación frecuente: oclusión de rama venosa o de vena central (hemorragias sectoriales en llama distales a un cruce AV, visión borrosa súbita e indolora); el HTA mal controlada es su principal factor de riesgo; derivar para anti-VEGF/láser.
- Prevención: control estricto de PA, tamizaje con fondo de ojo en hipertensos con repercusión visceral o control deficiente; derivar a oftalmología cuando haya hemorragias, exudados, edema de papila o baja visual.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 66 años, hipertenso con mal control, consulta por visión borrosa súbita e indolora en el ojo derecho desde ayer. Al fondo de ojo se observan hemorragias en llama y exudados algodonosos limitados al cuadrante temporal superior, distales a un cruce arteriovenoso, con la vena de ese sector dilatada y tortuosa. Papila sin edema. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Retinopatía hipertensiva grado IV

B Oclusión de la arteria central de la retina

C Retinopatía diabética proliferativa

D Oclusión de rama venosa retiniana

E Desprendimiento de retina regmatógeno

Respuesta D. Hemorragias en llama sectoriales, limitadas al territorio drenado por una vena, distales a un cruce arteriovenoso, son una oclusión de rama venosa. La hipertensión arterial es su principal factor de riesgo: la arteriola esclerosada comprime la vena en el cruce. La retinopatía hipertensiva es bilateral y difusa, y el grado IV exige edema de papila.

▶ VER CLASE 6.02.3.006 **Orbitopatía tiroidea**

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.6 · Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Orbitopatía tiroidea (de Graves): inflamación autoinmune de grasa y músculos extraoculares, presente en ~50 % de los Graves; proptosis, retracción palpebral (mirada fija), quemosis, ojo seco, diplopía por fibrosis de los rectos, y en graves compresión del nervio óptico. Mixedema pretibial y acropaquia confirman el cuadro.
- El tabaquismo la empeora: suspender el tabaco es parte del tratamiento. Mantener el eutiroidismo (evitar hipo e hipertiroidismo); el radioyodo puede empeorarla y exige prednisona profiláctica.
- Manejo en APS: lágrimas artificiales y ungüento nocturno, elevar la cabecera, lentes oscuros, selenio en formas leves, y derivar a endocrinología y oftalmología para clasificar actividad (CAS) y gravedad.
- Formas moderadas-severas activas: pulsos de metilprednisolona EV (con estudio hepático), radioterapia orbitaria o teprotumumab; urgencia: neuropatía óptica compresiva (baja de visión, discromatopsia, defecto pupilar aferente) o queratopatía por exposición: corticoides EV y descompresión orbitaria.
- Seguimiento: control conjunto endocrino-oftalmológico; cirugía rehabilitadora (descompresión, estrabismo, párpados) cuando la enfermedad está inactiva.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 41 años, fumadora de 15 cigarrillos al día, con enfermedad de Graves diagnosticada hace 2 meses, en tratamiento con tiamazol, actualmente eutiroidea. Refiere sensación de arenilla, lagrimeo y retracción palpebral leve bilateral, sin diplopía y con agudeza visual normal. Sin edema de papila ni alteración de la visión de colores. **¿Cuál es la medida que más disminuye el riesgo de progresión de su orbitopatía?**

A Radioyodo de inmediato para eliminar el hipertiroidismo

B Suspender completamente el tabaco

C Descompresión orbitaria quirúrgica

D Bolos de metilprednisolona endovenosa

E Aumentar el tiamazol hasta lograr TSH suprimida

Respuesta B. El tabaquismo es el principal factor de riesgo modificable de aparición y progresión de la orbitopatía de Graves. En la orbitopatía leve se indica cesación del tabaco, lubricantes, selenio y mantener el eutiroidismo. El radioyodo puede empeorarla; los corticoides EV se reservan para la forma activa moderada a severa y la descompresión para la neuropatía óptica.

Exámenes e imagenología

2 códigos

▶ VER CLASE 6.02.4.001 **Campo visual**

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.7 · Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG

QUÉ HAY QUE SABER

- Campo visual (campimetría computarizada, Humphrey): examen del especialista que mide la sensibilidad retiniana en distintas zonas del campo; el médico general lo interpreta y emplea el informe.
- Indicaciones: sospecha y seguimiento de glaucoma, neuropatías ópticas, enfermedades de la vía óptica (adenoma hipofisario, tumores), retinopatía y evaluación de pérdida visual de causa neurológica.
- Glaucoma: escotomas arciformes (Bjerrum) y escalón nasal que progresan a visión en túnel con conservación de la visión central hasta etapas tardías; el paciente «choca» con objetos laterales aunque lea bien.
- Otros patrones: hemianopsia bitemporal (quiasma, adenoma hipofisario), hemianopsia homónima (lesión retroquiasmática), escotoma central (maculopatía, neuritis óptica), mancha ciega agrandada (papiledema).
- Interpretar: defecto reproducible y progresivo en control seriado confirma daño funcional; combinar siempre con tonometría, fondo de ojo y OCT. Derivar para campimetría ante excavación papilar sospechosa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 64 años con glaucoma crónico de ángulo abierto, con mala adherencia a sus colirios, refiere que choca con objetos que están a sus lados, aunque lee bien. Agudeza visual 20/25 en ambos ojos. Se solicita campimetría computarizada. **¿Cuál es el patrón de campo visual más característico de su enfermedad avanzada?**

A Escotoma central con pérdida precoz de la visión de lectura

B Escotomas arciformes que progresan a una visión en túnel, con conservación de la visión central hasta etapas tardías

C Hemianopsia bitemporal

D Hemianopsia homónima derecha

E Metamorfopsia central

Respuesta B. El glaucoma daña las fibras del nervio óptico y produce escotomas arciformes y escalón nasal, que avanzan hacia la periferia hasta dejar solo una isla central: la visión en túnel. Por eso la agudeza visual se conserva hasta muy tarde y la campimetría es clave para el diagnóstico y el seguimiento.

▶ VER CLASE 6.02.4.002 **Cultivo de secreción conjuntival** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.2 · Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Cultivo de secreción conjuntival: examen que se interpreta y emplea en conjuntivitis neonatal, hiperaguda o gonocócica, crónica o refractaria, en inmunosuprimidos y en postoperatorio.
- Indicaciones prácticas: recién nacido con secreción purulenta abundante (Neisseria gonorrhoeae en 2–5 días; Chlamydia trachomatis a partir de 5–14 días, más escasa), conjuntivitis sin respuesta al antibiótico en 48–72 horas o crónica, uso de lentes de contacto con queratitis.
- Técnica: tomar la muestra antes de iniciar antibiótico, con tórula estéril del fondo de saco conjuntival inferior sin tocar pestañas ni párpado; Gram inmediato, medios para gonococo (agar chocolate) y PCR o inmunofluorescencia para Chlamydia.
- Interpretación: diplococos gramnegativos intracelulares = gonococo (ceftriaxona sistémica); Chlamydia en RN se trata con azitromicina o eritromicina oral y se tratan los padres.
- Emplear el resultado para ajustar antibiótico y estudiar/tratar a la madre y su pareja; derivar de urgencia a oftalmología las formas hiperagudas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de 3 días con secreción conjuntival purulenta abundante, bilateral, con edema palpebral marcado y quemosis. La madre no tuvo control prenatal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Lavado con suero y control en 1 semana

B Masaje del saco lagrimal

C Colirio de cloranfenicol y alta

D Tomar Gram y cultivo de secreción conjuntival (incluyendo medios para gonococo y estudio de Chlamydia) e iniciar ceftriaxona sistémica

E Corticoide tópico

Respuesta D. La conjuntivitis neonatal hiperaguda en los primeros días sugiere Neisseria gonorrhoeae, que puede perforar la córnea. Se toma Gram y cultivo de la secreción (y estudio de Chlamydia, más típica entre los 5 y 14 días) antes de tratar, y se inicia ceftriaxona sistémica con lavados frecuentes. Se estudia y trata a la madre y su pareja.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

14 códigos

▶ VER CLASE 6.02.5.001 **Aplicación de ungüentos** NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.2 · Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: administrar antibióticos en ungüento oftálmico (cloranfenicol, eritromicina) en conjuntivitis bacteriana, blefaritis, protección corneal nocturna o tras curación de abrasiones.
- Técnica: lavado de manos, sentar o acostar al paciente con la cabeza hacia atrás, traccionar suavemente el párpado inferior hacia abajo y depositar una franja de unos 1 cm de ungüento en el fondo de saco conjuntival inferior sin que la punta del tubo toque el ojo ni las pestañas.
- Cerrar suavemente los párpados sin frotar; la visión queda borrosa unos minutos. Si se usan colirios, instilar primero los colirios (esperar 5 minutos) y aplicar el ungüento al final.
- Educar: no compartir el envase, desechar tras el tratamiento, retirar lentes de contacto, completar el esquema (habitualmente 5–7 días).
- Contraindicaciones/derivación: ungüentos con corticoides no se usan sin diagnóstico oftalmológico; derivar si hay dolor, baja de visión o falta de respuesta.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Se indica ungüento oftálmico de cloranfenicol a un paciente con conjuntivitis bacteriana y se le enseña cómo aplicarlo. **¿Cuál es la técnica correcta?**

A Aplicar el ungüento directamente sobre la córnea con la punta del tubo apoyada en el ojo

B Aplicar sobre la piel del párpado superior

C Lavarse las manos, traccionar suavemente el párpado inferior hacia abajo, depositar una franja de 1 cm de ungüento en el fondo de saco conjuntival inferior sin tocar el ojo con el tubo, y cerrar suavemente los párpados

D Frotar el ojo después de aplicarlo para distribuirlo

E Aplicar antes de los colirios para que actúen mejor

Respuesta C. El ungüento se aplica con manos limpias en el fondo de saco conjuntival inferior, traccionando el párpado inferior, en una franja de 1 cm, sin que la punta toque el ojo ni las pestañas. Luego se cierra el ojo suavemente, sin frotar. Si se usan colirios, el ungüento va al final, porque impide su absorción.

▶ VER CLASE 6.02.5.002 Campo visual por confrontación

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.20 · Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Campo visual por confrontación: examen de tamizaje con el examinador y paciente frente a frente a ~1 metro, cada ojo por separado (se ocluye el otro); el paciente fija la nariz del examinador y se compara con el campo propio.
- Técnica: con el brazo extendido, mostrar 1–5 dedos o mover un objeto desde la periferia hacia el centro en los cuatro cuadrantes (superior, inferior, temporal y nasal); el paciente indica cuándo ve los dedos o el objeto. Probar ambos ojos.
- Interpretación: hemianopsia bitemporal (compresión del quiasma, adenoma hipofisario con choque con muebles o autos), hemianopsia homónima (lesión retroquiasmática), pérdida concéntrica (glaucoma avanzado), escotoma central o altitudinal.
- Es un examen de pesquisa: no reemplaza la campimetría computarizada, pero permite sospechar lesiones del quiasma, vía óptica y glaucoma y derivar.
- Ante defecto campimétrico: solicitar resonancia de silla turca/cerebro y perfil hormonal si hay hemianopsia bitemporal, y derivar a oftalmología y neurología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 50 años con cefalea de meses y choques frecuentes con objetos a ambos lados. Al examinar el campo visual por confrontación, sentado frente a él a 1 metro, el paciente no detecta los dedos del examinador en las mitades temporales de ambos campos visuales. **¿Qué lesión sugiere este hallazgo?**

A Lesión del quiasma óptico, como un macroadenoma hipofisario

B Lesión del nervio óptico derecho

C Lesión de la cintilla óptica izquierda

D Lesión del lóbulo occipital derecho

E Glaucoma crónico

Respuesta A. El campo visual por confrontación compara el campo del paciente con el del examinador, cada ojo por separado y por cuadrantes. La hemianopsia bitemporal indica compresión del quiasma (cruce de fibras nasales), típicamente por macroadenoma hipofisario o craneofaringioma; se estudia con resonancia selar y campimetría computarizada. Las lesiones retroquiasmáticas dan hemianopsias homónimas.

▶ VER CLASE 6.02.5.003 Colocación de sello ocular

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.15 · Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Sello ocular (oclusión): protege el ojo, alivia el dolor y facilita el traslado en abrasiones corneales o tras extraer un cuerpo extraño; se coloca con el párpado cerrado.
- Técnica: cerrar el párpado, colocar una o dos gasas dobladas sobre el ojo y fijar con 2–3 cintas adhesivas oblicuas desde la frente al pómulo, firme pero sin presionar el globo.
- Si se sospecha globo abierto o perforación NO se coloca sello compresivo: se usa una concha rígida fenestrada apoyada en el reborde óseo, sin tocar el ojo.
- Contraindicado en usuarios de lentes de contacto (riesgo de infección por Pseudomonas), en úlceras o infecciones corneales (el parche favorece el crecimiento bacteriano) y no reemplaza la irrigación en causticaciones.
- No mantener más de 24 horas sin control; indicar acudir si aumenta el dolor o la visión empeora.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años, soldador, consulta en el SAPU por sensación de cuerpo extraño en el ojo derecho. Se le extrae un cuerpo extraño corneal superficial y la tinción con fluoresceína muestra una erosión corneal de 2 mm. No usa lentes de contacto. Se decide ocluir el ojo para su traslado y comodidad. **Respecto de la colocación del sello ocular, ¿cuál afirmación es correcta?**

A Se debe ocluir con el ojo abierto para permitir la salida de lágrimas

B Se recomienda en usuarios de lentes de contacto con erosión corneal

C Está indicado en toda cauticación ocular antes de irrigar

D Se pone con el párpado cerrado, gasas sobre el ojo y tela adhesiva oblicua desde la frente al pómulo, sin presionar el globo si se sospecha perforación

E Debe mantenerse al menos 7 días sin retirarlo

Respuesta D. El sello se coloca con el párpado cerrado, gasa doblada sobre el ojo y cintas adhesivas oblicuas de frente a pómulo, firme pero sin presión si existe riesgo de perforación (en ese caso, concha rígida). Está contraindicado en usuarios de lentes de contacto por riesgo de Pseudomonas y nunca reemplaza la irrigación en cauticaciones.

▶ VER CLASE 6.02.5.004 Cover test

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.9 · Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Cover test (prueba de oclusión): permite detectar y clasificar estrabismo manifiesto (tropia). Se pide al niño fijar un objeto y se tapa un ojo mientras se observa el movimiento del otro.
- Interpretación: si el ojo descubierto se mueve para tomar la fijación estaba desviado: movimiento de afuera hacia adentro = exotropia; de adentro hacia afuera = endotropia; sin movimiento al ocluir cada ojo = ortotropia. El cover alternante pesquisa forias.
- Técnica: fijación a 33 cm y 6 metros, luz y atención del niño, ocluir con la mano o paleta durante 2–3 segundos, repetir con el otro ojo; complementa el test de Hirschberg.
- Todo estrabismo o duda en un niño se deriva a oftalmología por riesgo de ambliopía; no usar parches sin evaluación previa.
- Realizar en controles de salud desde los 6 meses; en <6 meses el estrabismo intermitente puede ser fisiológico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 3 años; los padres notan que a veces "se le va un ojo". El reflejo corneal es simétrico. Al realizar el cover test, al tapar el ojo izquierdo, el ojo derecho no se mueve; al tapar el ojo derecho, el ojo izquierdo hace un movimiento de afuera hacia adentro para fijar. **¿Cuál es la interpretación del examen?**

A Examen normal

B Exotropia del ojo izquierdo (estrabismo divergente); derivar a oftalmología

C Endotropia del ojo izquierdo

D Pseudoestrabismo por epicanto

E Exotropia del ojo derecho

Respuesta B. En el cover test (oclusión unilateral) se tapa un ojo y se observa el otro: si el ojo descubierto se mueve para tomar la fijación, estaba desviado. Un movimiento de afuera hacia adentro indica que estaba desviado hacia afuera (exotropia); de adentro hacia afuera, endotropia. Todo estrabismo en un niño se deriva por riesgo de ambliopía.

▶ VER CLASE 6.02.5.005 Eversión palpebral

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.15 · Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Eversión palpebral: maniobra para ver la conjuntiva tarsal superior, donde se alojan cuerpos extraños, papilas (alergia) y folículos; se indica ante sensación de cuerpo extraño, erosiones corneales lineales verticales y ojo rojo con fluoresceína positiva.
- Técnica: pedir al paciente mirar hacia abajo, tomar las pestañas del párpado superior con una mano, apoyar un aplicador de algodón sobre el borde superior del tarso, y traccionar hacia arriba y adelante para voltear el párpado (como una «página»); mantener evertido mientras se examina.
- Hallazgos: cuerpo extraño adherido a la conjuntiva tarsal, papilas en empedrado (conjuntivitis alérgica/vernal), folículos (viral, tracoma) o cicatrización.
- Contraindicado en sospecha de herida penetrante o globo abierto, o en trauma severo (no presionar el globo).
- Si hay cuerpo extraño, retirarlo con un hisopo húmedo bajo anestesia tópica y luego indicar antibiótico tópico; el médico general realiza el procedimiento.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 91

Paciente de 50 años, sin antecedentes, consulta por ojo rojo izquierdo desde ayer, asociado a dolor, blefaroespasmo y fotofobia. Por el dolor, el examen es dificultoso, por lo que se administra anestésico local; se aprecia ojo rojo y, al aplicar fluoresceína, se tiñen múltiples erosiones lineales verticales en la mitad superior de la córnea. **¿Cuál es la conducta más apropiada en este caso?**

A Evertir el párpado superior
B Aplicar colirio de gentamicina
C Poner parche ocular y controlar
D Aplicar colirio con atropina
E Realizar aseo local

Respuesta A. Erosiones corneales lineales verticales en la mitad superior sugieren un cuerpo extraño alojado en la conjuntiva tarsal superior, que raspa la córnea con cada parpadeo. Se debe evertir el párpado superior para buscarlo y extraerlo con hisopo húmedo. Luego se indica antibiótico tópico. El parche sin retirar el cuerpo extraño perpetúa el daño.

▶ VER CLASE 6.02.5.006 Examen de rojo pupilar con oftalmoscopio

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.9 · Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen del rojo pupilar (test de Brückner): con oftalmoscopio directo a unos 50 cm a 1 metro, en penumbra, iluminando ambos ojos a la vez; se compara el reflejo rojo anaranjado de las pupilas.
- Normal: reflejo rojo simétrico y brillante. Anormal: reflejo ausente, blanco (leucocoria), amarillento o asimétrico; en adultos, reflejo atenuado o con manchas oscuras indica catarata.
- Indicación: en todo recién nacido y en cada control del lactante y del preescolar, y en adultos con baja de visión (catarata).
- Leucocoria o asimetría exige derivación urgente a oftalmología para descartar retinoblastoma, catarata congénita, retinopatía del prematuro o desprendimiento de retina; la catarata congénita debe operarse precozmente para evitar ambliopía profunda.
- Es un examen que el médico general realiza: no tranquilizar ante reflejo anormal ni esperar al próximo control.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En el control de un lactante de 2 meses se realiza el examen del rojo pupilar con oftalmoscopio directo a 50 cm, en penumbra, iluminando ambos ojos simultáneamente (test de Brückner). El ojo derecho muestra rojo pupilar normal y el izquierdo un reflejo blanco. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Repetir el examen en el próximo control a los 6 meses
B Tranquilizar, porque es normal en lactantes
C Indicar colirio antibiótico
D Derivación urgente a oftalmología por leucocoria (descartar catarata congénita y retinoblastoma)
E Solicitar ecografía cerebral

Respuesta D. El rojo pupilar se examina en todo recién nacido y en los controles de salud. Un reflejo ausente, blanco (leucocoria) o asimétrico obliga a derivación urgente a oftalmología para descartar catarata congénita (que debe operarse precozmente para evitar ambliopía profunda), retinoblastoma, retinopatía del prematuro u otras causas.

▶ VER CLASE 6.02.5.007 Extracción de cuerpo extraño tarsal

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.15 · Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Cuerpo extraño tarsal: partícula alojada en la conjuntiva tarsal superior que provoca arenilla, lagrimeo y erosiones corneales lineales verticales que se tiñen con fluoresceína (típicas de la mitad superior de la córnea).
- Técnica: instilar anestésico tópico, evertir el párpado superior, localizar la partícula y retirarla con un hisopo de algodón humedecido en suero fisiológico con un barrido suave.
- Si el cuerpo extraño está incrustado en la córnea, no intentar con el hisopo: derivar a oftalmología; sospechar globo abierto o cuerpo extraño intraocular si hubo alta velocidad.
- Después del retiro: antibiótico tópico (ungüento o colirio) y control a las 24–48 horas; no dar anestésico tópico para uso en domicilio ni corticoides, y no ocluir en usuarios de lentes de contacto.
- El médico general realiza el procedimiento; derivar si persiste dolor, hay úlcera corneal, óxido residual o baja de visión.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 30 años con sensación de arenilla en el ojo derecho tras andar en bicicleta. Al evertir el párpado superior se observa una partícula negra adherida a la conjuntiva tarsal. La córnea muestra erosiones lineales superficiales con fluoresceína. **¿Cuál es la técnica de extracción más adecuada?**

A Extraer con una aguja de calibre 18 sin anestesia

B Lavar con agua de la llave y no evertir

C Bajo anestesia tópica, retirar la partícula con un hisopo de algodón humedecido en suero, luego indicar antibiótico tópico

D Dejar que salga sola con el parpadeo y control en 48 horas

E Indicar corticoide tópico y parche

Respuesta C. El cuerpo extraño tarsal superior se extrae evirtiendo el párpado y barriéndolo con un hisopo de algodón húmedo, tras anestesia tópica. Las agujas se reservan para cuerpos extraños corneales incrustados y en manos entrenadas. Después se indica antibiótico tópico y se controla la erosión corneal. Los corticoides tópicos y el uso de anestésico como tratamiento están contraindicados.

▶ VER CLASE 6.02.5.008 Extracción de pestañas distiquiásicas

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.3 · Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Distiquiasis: pestañas aberrantes que nacen del borde posterior del párpado, de los orificios de las glándulas de Meibomio, y se dirigen hacia el globo; se asocia a blefaritis crónica, tracoma, cicatrices o quemaduras químicas.
- Cuadro: sensación de cuerpo extraño crónico, ojo rojo, lagrimeo y fotofobia; con lupa se ven las pestañas rozando la córnea y tinción con fluoresceína punteada (erosiones, úlceras o leucomas).
- Manejo inicial en APS: lubricantes (lágrimas artificiales o ungüento) y protección de la córnea; la extracción con pinza solo la hace el especialista.
- Como las pestañas vuelven a crecer en semanas, el tratamiento definitivo destruye el folículo (electrólisis, crioterapia, láser o cirugía) y lo indica oftalmología. No cortar con tijera (la punta rígida daña más).
- Derivar a oftalmología; urgente si hay úlcera corneal, dolor intenso o baja de visión.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 60 años con sensación de cuerpo extraño crónico y ojo rojo derecho. Al examen con lupa se observan 3 pestañas que nacen desde la línea de las glándulas de Meibomio, dirigidas hacia el globo ocular, rozando la córnea, que muestra erosiones puntiformes con fluoresceína. **¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A Antibiótico tópico crónico

B Cortar las pestañas con tijera a ras de piel

C Corticoide tópico

D Parche ocular permanente

E Depilación (extracción) de las pestañas aberrantes con pinza y lubricación; derivar para tratamiento definitivo (electrólisis, crioterapia) si recurren

Respuesta E. La distiquiasis (pestañas que nacen de los orificios de las glándulas de Meibomio) roza la córnea y causa erosiones, úlceras y leucomas. El manejo inicial es depilar con pinza bajo lupa y lubricar; como vuelven a crecer en semanas, el tratamiento definitivo destruye el folículo (electrólisis, crioterapia o cirugía). Cortarlas deja una punta rígida dañina.

▶ VER CLASE 6.02.5.009 Instilación de colirios

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.7 · Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: administrar colirios (antibióticos, antiglaucomatosos, lubricantes, antihistamínicos, midriáticos) en forma correcta y enseñar la técnica al paciente.
- Técnica: lavado de manos, cabeza hacia atrás mirando hacia arriba, traccionar suavemente el párpado inferior, instilar 1 gota en el fondo de saco conjuntival inferior sin tocar el ojo ni las pestañas con el gotario (el saco solo retiene una gota; más gotas rebasan).
- Cerrar suavemente los ojos y ocluir el punto lagrimal (presión del canto interno) 1–2 minutos para aumentar el contacto y reducir la absorción sistémica (broncoespasmo y bradicardia con timolol). No parpadear con fuerza.
- Si se usan varios colirios, esperar 5 minutos entre uno y otro; los ungüentos van al final; retirar lentes de contacto antes de aplicar; no compartir los frascos y desechar al mes de abierto.
- Precauciones: no usar midriáticos en ángulo estrecho no tratado, ni corticoides sin diagnóstico; betabloqueadores tópicos contraindicados en asma y bloqueo AV.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 70 años con glaucoma crónico y asma leve inicia timolol en colirio. Se le enseña la técnica de instilación. **¿Cuál es la técnica que además reduce la absorción sistémica del fármaco?**

A Instilar 3 gotas para asegurar el efecto

B Aplicar 2 colirios distintos al mismo tiempo

C Parpadear rápidamente varias veces tras la instilación

D Instilar directamente sobre la córnea con el gotario apoyado

E Instilar 1 gota en el fondo de saco inferior y luego cerrar los ojos y presionar el canto interno (oclusión del punto lagrimal) durante 1 a 2 minutos

Respuesta E. Se instila 1 gota (el fondo de saco solo retiene una) traccionando el párpado inferior, sin tocar el ojo. Luego se cierran los ojos y se comprime el canto interno 1 a 2 minutos: aumenta el contacto y disminuye el paso a la mucosa nasal, reduciendo efectos sistémicos como broncoespasmo y bradicardia por betabloqueadores.

▶ VER CLASE 6.02.5.010 Oftalmoscopía directa

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Oftalmología 15.7 · Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG
Oftalmología 15.13 · Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar

QUÉ HAY QUE SABER

- Oftalmoscopía directa: examen de fondo de ojo con oftalmoscopio en una habitación en penumbra, acercándose al ojo del paciente (a ~2 cm) con el ojo derecho del examinador para el ojo derecho del paciente; con pupila dilatada se amplía el campo (evitar dilatar si hay riesgo de ángulo estrecho).
- Qué evaluar: reflejo rojo, papila (bordes, color, relación excavación/papila: sospecha de glaucoma si >0,5 o asimetría >0,2), vasos retinianos (cruces AV, calibre), mácula y retina periférica posible.
- Hallazgos clave: edema de papila bilateral (hipertensión intracraneal o retinopatía hipertensiva grado IV); hemorragias, exudados y neovasos (retinopatía diabética o hipertensiva); mancha rojo cereza (oclusión arterial); retina pálida y desprendida; papila excavada (glaucoma).
- Indicado en diabéticos (tamizaje anual), hipertensos, cefalea con sospecha de hipertensión endocraneana, baja de visión y sospecha de glaucoma.
- Es un procedimiento que el médico general realiza; si hay hallazgos patológicos, se deriva a oftalmología para oftalmoscopía indirecta, OCT o retinografía.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 63 años con hipertensión arterial crónica acude a control. En el fondo de ojo se observan arteriolas retinianas estrechadas de aspecto brillante y cobrizo, y a nivel de los cruces arteriovenosos se aprecia un aflamiento y ocultamiento del trayecto de las vénulas por debajo de las arteriolas (signo de Gunn positivo), sin hemorragias ni exudados. **¿A qué grado de la clasificación de Keith-Wagener-Barker corresponde este hallazgo?**

A Grado I

B Grado II

C Grado III

D Grado IV

E Retinopatía proliferativa grado B

Respuesta B. Cruces arteriovenosos patológicos (signo de Gunn o de Salus), junto con esclerosis arteriolar, sin hemorragias, exudados ni edema de papila, definen el grado II de Keith-Wagener-Barker. El grado I solo tiene estrechamiento arteriolar; el grado III añade hemorragias y exudados; el grado IV suma edema de papila.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 56 años, sin síntomas visuales, acude a control de salud. Su hermano mayor fue diagnosticado de glaucoma avanzado el año pasado. Agudeza visual 20/20 bilateral. Al fondo de ojo: papila rosada, con excavación papilar de 0,7 en el ojo derecho y 0,4 en el izquierdo, con rechazo nasal de los vasos en el ojo derecho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tranquilizar: la agudeza visual normal descarta glaucoma

B Derivar a oftalmología para campimetría, OCT y tonometría

C Iniciar timolol tópico de inmediato sin derivar

D Indicar solo control en 5 años, por ser asintomático

E Solicitar una resonancia magnética de órbitas

Respuesta B. Antecedente familiar de primer grado, excavación papilar aumentada y asimétrica, con rechazo nasal de vasos: alta sospecha de glaucoma crónico. Se deriva a oftalmología para confirmar con campimetría, OCT y tonometría, aunque la agudeza visual esté conservada.

▶ VER CLASE 6.02.5.011 Reflejos pupilares

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Oftalmología 15.18 · Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

QUÉ HAY QUE SABER

- Reflejos pupilares: fotomotor directo y consensual (vía aferente por nervio óptico, eferente por III par), acomodativo y prueba de la linterna oscilante; examinar en penumbra, con luz uniforme y fijación a distancia.
- Defecto pupilar aferente relativo (Marcus Gunn): al pasar la luz del ojo sano al enfermo ambas pupilas se dilatan paradójicamente; signo más sensible de lesión asimétrica del nervio óptico (neuritis óptica, glaucoma avanzado, oclusión arterial) o retina extensa.

- Lesión eferente del III par: pupila dilatada que no reacciona a la luz directa ni consensual, con ptosis y ojo abajo y afuera; con cefalea sospechar aneurisma de comunicante posterior. Midriasis media fija con dolor y ojo pétreo: glaucoma agudo. Miosis hiporreactiva: uveítis anterior. Horner: miosis, ptosis y anhidrosis. Pupila tónica de Adie: grande y de respuesta lenta.
- Pupilas mióticas puntiformes en intoxicación por opioides u organofosforados; midriasis en anticolinérgicos o muerte encefálica.
- El médico general realiza el examen; derivar de urgencia anisocoria nueva con ptosis, cefalea, trauma o baja visual.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años consulta por caída del párpado derecho y visión doble de 1 día de evolución, con cefalea intensa. Al examen, el ojo derecho está desviado hacia abajo y afuera, con ptosis completa. La pupila derecha mide 7 mm y no reacciona a la luz directa ni consensual; la pupila izquierda mide 3 mm y reacciona a la luz directa y consensual. **¿Cuál es la interpretación más adecuada de estos hallazgos?**

A Defecto pupilar aferente relativo derecho por neuritis óptica

B Síndrome de Horner derecho

C Lesión eferente del tercer par derecho, sospechar aneurisma de comunicante posterior

D Pupila de Argyll Robertson

E Anisocoria fisiológica

Respuesta C. Si la pupila afectada no responde ni a la luz directa ni a la consensual, el defecto es eferente (tercer par). Un tercer par con midriasis y cefalea obliga a descartar aneurisma de comunicante posterior con angio-TC urgente. En el defecto aferente, la pupila sí contrae con la luz del ojo sano.

▶ VER CLASE 6.02.5.012 Tensión ocular palpatoria

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.6 · Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida

QUÉ HAY QUE SABER

- Tensión ocular palpatoria: estimación grosera de la presión intraocular cuando no hay tonómetro; útil en sospecha de glaucoma agudo (ojo pétreo) o de herida/perforación (ojo blando).
- Técnica: paciente con la mirada hacia abajo y los párpados cerrados; apoyar ambos índices sobre el párpado superior y presionar suave y alternadamente sobre el globo, comparando con el otro ojo.
- Interpretación: un ojo duro como piedra, asimétrico respecto al otro, apoya glaucoma agudo; un ojo muy blando sugiere herida penetrante o ruptura del globo.
- Contraindicado en sospecha de perforación ocular, trauma abierto, hifema o úlcera corneal profunda (no presionar el globo); nunca presionar la córnea ni mantener la presión por tiempo prolongado.
- No mide mmHg: derivar para tonometría. Ante ojo pétreo con síntomas, iniciar hipotensores (manitol, acetazolamida, timolol) y derivar de urgencia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 66 años, hipermétrope, consulta en un servicio de urgencia sin tonómetro por dolor ocular izquierdo intenso, náuseas y visión de halos alrededor de las luces. Se decide estimar la presión intraocular por palpación bidigital. **¿Cuál es la técnica e interpretación correctas?**

A Con la paciente mirando hacia abajo y los ojos cerrados, palpar alternadamente con ambos índices sobre el párpado superior, comparando con el otro ojo; un ojo duro como piedra sugiere presión muy elevada

B Con la paciente mirando hacia arriba, presionar directamente la córnea con ambos índices

C Presionar el globo ocular con fuerza durante 1 minuto para evaluar el reflejo oculocardíaco

D Palpar el párpado inferior con la paciente mirando hacia arriba; un ojo blando sugiere glaucoma agudo

E La palpación permite medir la presión exacta en milímetros de mercurio

Respuesta A. La tensión ocular palpatoria se realiza con la mirada hacia abajo y los párpados cerrados, presionando suave y alternadamente con ambos índices sobre el párpado superior, comparando ambos ojos. Es solo una estimación grosera: un ojo duro como piedra, asimétrico respecto al otro, apoya un glaucoma agudo. Nunca se presiona la córnea.

▶ VER CLASE 6.02.5.013 Test de Hirschberg (imagen especular de la córnea)

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.9 · Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Test de Hirschberg (imagen especular de la córnea): se ilumina con una linterna a 30–40 cm de la cara mientras el niño fija la luz, y se observa la posición del reflejo corneal en ambas pupilas.
- Normal: reflejo centrado y simétrico (levemente nasal, 0–0,5 mm). Si el reflejo está desplazado hacia temporal, el ojo está desviado hacia adentro (endotropia); si está hacia nasal, desviado hacia afuera (exotropia). Cada mm de desplazamiento equivale a unos 7° (15 dioptrías prismáticas).
- Útil para tamizaje de estrabismo en lactantes y niños que no colaboran; no detecta forias ni desviaciones pequeñas (completar con cover test). Descartar pseudoestrabismo por epicanto (reflejo simétrico).
- Ante asimetría se deriva a oftalmología por riesgo de ambliopía (ventana hasta 7–8 años); asociar examen del rojo pupilar.
- El médico general realiza el test en cada control infantil desde los 6 meses.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 2 años en control sano. Se ilumina con una linterna desde 30 cm frente a su cara mientras fija la luz. En el ojo derecho el reflejo luminoso corneal está centrado en la pupila; en el ojo izquierdo está desplazado hacia el borde temporal de la pupila. **¿Cuál es la interpretación?**

A Endotropia (estrabismo convergente) del ojo izquierdo

B Normal

C Exotropia del ojo izquierdo

D Hipertropia del ojo derecho

E Ambliopía sin estrabismo

Respuesta A. En el test de Hirschberg el reflejo corneal debe estar centrado y simétrico. Si en un ojo el reflejo está desplazado hacia temporal, la córnea apunta hacia nasal: endotropia; si está desplazado hacia nasal, exotropia. Cada milímetro de desplazamiento equivale a unos 7 grados de desviación. Ante asimetría se deriva a oftalmología por riesgo de ambliopía.

▶ VER CLASE 6.02.5.014 **Toma de visión** NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.9 · Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Toma de visión (agudeza visual): se realiza de manera monocular con tabla de Snellen o de optotipos a 6 metros, con buena iluminación, cubriendo el otro ojo sin presionarlo; primero sin corrección y luego con lentes si los usa.
- Registrar la línea más pequeña leída (20/20 normal; 20/40, etc.); en niños usar optotipos adecuados a la edad (E de Snellen, figuras); a los 5 años se espera 20/30 a 20/20.
- Si la AV está disminuida, repetir con agujero estenopeico: mejora = vicio de refracción; no mejora = lesión orgánica (catarata, maculopatía, neuritis) o ambliopía.
- Una diferencia de 2 o más líneas entre ambos ojos es anormal en niños (ambliopía por anisometropía) y obliga a derivar; en adultos, baja brusca de visión es urgencia.
- Es un examen básico que el médico general debe realizar y registrar en cada control (adulto y niño).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 5 años en control de salud escolar. Se toma la agudeza visual con tabla de Snellen (optotipos) a 6 metros, con buena iluminación, cada ojo por separado. Resultado: ojo derecho 20/20 y ojo izquierdo 20/50; con agujero estenopeico el ojo izquierdo mejora a 20/25. **¿Cuál es la interpretación y conducta más adecuada?**

A Normal para la edad; control en 2 años

B Disminución de agudeza visual del ojo izquierdo probablemente por vicio de refracción, con diferencia de 2 o más líneas entre ojos; derivar a oftalmología para refracción por riesgo de ambliopía

C Ambliopía irreversible; no requiere estudio

D Catarata; derivar para cirugía

E Repetir la toma con ambos ojos abiertos

Respuesta B. La agudeza visual se toma monocularmente a la distancia indicada. A los 5 años se espera 20/30 a 20/20; una diferencia de 2 o más líneas entre ojos es anormal. La mejoría con agujero estenopeico indica un vicio de refracción corregible. Por el riesgo de ambliopía (anisometropía), se deriva para refracción y corrección óptica.

18

OTORRINOLARINGOLOGÍA

83 CÓDIGOS

135 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	33
Situaciones clínicas de urgencia	18
Conocimientos generales	7
Exámenes e imagenología	11
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	14

Situaciones clínicas

33 códigos

▶ VER CLASE 6.03.1.001 Alergia nasosinusal

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.9 · Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales

QUÉ HAY QUE SABER

- Rinitis alérgica: estornudos en salva, rinorrea acuosa, prurito nasal/ocular y obstrucción; mucosa pálida y edematosa. Asocia asma y dermatitis atópica.
- Clasificación ARIA: intermitente (<4 días/semana o <4 semanas) vs persistente; leve vs moderada-severa (afecta sueño, trabajo o actividades).
- Leve intermitente: antihistamínico oral de 2ª generación (loratadina 10 mg/día, cetirizina 10 mg/día). Persistente o moderada-severa: corticoide intranasal (mometasona/fluticasona) diario, el más eficaz.
- Evitar alérgenos (ácaros, epitelios, pólenes), lavado nasal con suero fisiológico. No usar oximetazolina más de 5 días: rinitis medicamentosa.
- Diferencial: rinitis no alérgica (vasomotora, medicamentosa, hormonal) y rinosinusitis. Pruebas cutáneas o IgE específica si no responde o se plantea inmunoterapia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 146

Un paciente de 8 años de edad, con historia de un año de evolución de rinorrea mucopurulenta bilateral intermitente asociado a prurito y en algunas ocasiones a epistaxis, actualmente sin síntomas. El tratamiento de elección en este caso es: **El tratamiento de elección en este caso es:**

A Antihistamínicos orales
B Antibióticos orales
C Corticoides tópicos
D Derivar a cirugía de adenoides
E Oximetazolina tópica

Respuesta A. Es una rinitis alérgica intermitente, sin obstrucción: se trata con antihistamínicos orales. Los corticoides tópicos se reservan para cuando hay obstrucción nasal.

▶ VER CLASE 6.03.1.002 Amigdalitis aguda

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.13 · Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

QUÉ HAY QUE SABER

- Faringoamigdalitis bacteriana (S. pyogenes): fiebre >38 °C, exudado amigdalino, adenopatías cervicales anteriores dolorosas, sin tos ni coriza; típico 5-15 años.
- Criterios de Centor/McIsaac orientan; tos, coriza, conjuntivitis o disfonía sugieren etiología viral (lo más frecuente, sobre todo <3 años).
- Tratamiento: penicilina benzatina 1.200.000 UI IM dosis única (600.000 UI si <27 kg) o amoxicilina 50 mg/kg/día por 10 días. Alergia: macrólido.
- Objetivo del antibiótico: prevenir fiebre reumática y complicaciones supuradas; analgesia con paracetamol o ibuprofeno.
- Diferencial: mononucleosis (adenopatías posteriores, esplenomegalia; amoxicilina da exantema). Trismus, voz de papa o desviación de úvula: absceso periamigdalino.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 8 años consulta con fiebre de 38,9 °C y odinofagia intensa de 24 horas, sin tos, rinorrea ni diarrea. Tiene amígdalas hiperémicas con exudado pultáceo en placas, petequias en el paladar blando y adenopatías anteriores bilaterales de 2 cm muy sensibles. El resto del examen es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tratamiento sintomático solamente, porque casi todas son virales
B Amoxicilina oral 50 mg/kg/día durante 10 días
C Amoxicilina oral durante 5 días
D Ceftriaxona endovenosa con hospitalización
E Esperar el resultado de la serología para Epstein-Barr

Respuesta B. McIsaac 5 puntos: edad de 3 a 14 años, fiebre, exudado, adenopatías anteriores dolorosas y ausencia de tos. Probabilidad de estreptococo de 50 a 60%: tratamiento con penicilina benzatina (600.000 UI, o 1.200.000 UI si pesa más de 27 kg) o amoxicilina por 10 días completos, para prevenir la fiebre reumática.

▶ VER CLASE 6.03.1.003 Amigdalitis crónica

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.15 · Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Amigdalitis crónica/recurrente: episodios repetidos documentados, halitosis, cáseum, adenopatías persistentes u odinofagia crónica.
- Criterios de Paradise para amigdalectomía: ≥7 episodios en 1 año, ≥5/año por 2 años o ≥3/año por 3 años.
- Otras indicaciones quirúrgicas: absceso periamigdalino recurrente, hipertrofia obstructiva con apnea del sueño, asimetría amigdalina sospechosa de neoplasia.

- Manejo inicial: tratar cada episodio agudo con penicilina/amoxicilina, higiene oral; registrar episodios para fundamentar la derivación.
- Derivar a otorrinolaringología para evaluar amigdalectomía; amígdala unilateral aumentada en adulto obliga a descartar linfoma o carcinoma.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 8 años con 8 episodios de faringoamigdalitis estreptocócica documentados y tratados en el último año, con ausentismo escolar importante. Entre episodios está asintomático. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Penicilina benzatina mensual indefinida

B Tratar cada episodio y controlar sin otra medida

C Derivar a otorrinolaringología para evaluar amigdalectomía

D Amigdalectomía solo si presenta absceso periamigdalino

E Solicitar ASO mensual

Respuesta C. La amigdalitis recurrente documentada con 7 o más episodios en 1 año, 5 o más por año en 2 años o 3 o más por año en 3 años (criterios de Paradise) indica evaluar amigdalectomía, al igual que el SAHOS por hipertrofia o el absceso periamigdalino recurrente. La penicilina profiláctica es para prevenir recurrencia de fiebre reumática.

▶ VER CLASE 6.03.1.004 Cáncer de boca, labios y orofaringe

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.20 · Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

QUÉ HAY QUE SABER

- Carcinoma escamoso en >90%; factores de riesgo: tabaco, alcohol, VPH-16 (orofaringe, pacientes más jóvenes), exposición solar (labio inferior).
- Sospechar ante úlcera, leucoplasia o eritroplasia oral que no cura en >2-3 semanas, odinofagia u otalgia refleja persistente, o adenopatía cervical dura.
- Eritroplasia tiene mayor riesgo de malignidad que leucoplasia; ambas requieren biopsia.
- Manejo inicial: suspender tabaco y alcohol, analgesia; no dar ciclos repetidos de antibiótico ante lesión que no cura.
- Derivar a otorrinolaringología o cabeza y cuello para biopsia y etapificación; adenopatía cervical en adulto fumador es cáncer hasta demostrar lo contrario.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 64 años, fumador de 40 paquetes-año y bebedor diario, consulta por una úlcera indolora de 1,5 cm, de bordes indurados, en el borde lateral izquierdo de la lengua, de 6 semanas de evolución. Hace 3 semanas se retiró una prótesis dental que la rozaba, pero la lesión no ha cicatrizado. No se palpan adenopatías cervicales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Enjuagues con clorhexidina y control en 3 meses

B Cauterización con nitrato de plata

C Aciclovir oral por 7 días

D Nistatina en suspensión oral

E Biopsia de la lesión

Respuesta E. Una úlcera, leucoplaquia o eritroplasia que no cicatriza en 2 semanas, sobre todo indurada, en el borde lateral de la lengua de un fumador y bebedor, es un carcinoma escamoso hasta demostrar lo contrario. Se biopsia y se deriva a cabeza y cuello para etapificar. Observar o tratar empíricamente retrasa el diagnóstico.

▶ VER CLASE 6.03.1.005 Cáncer laríngeo e hipofaríngeo

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.20 · Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

QUÉ HAY QUE SABER

- Carcinoma escamoso asociado a tabaco y alcohol; glótico da disfonía precoz (mejor pronóstico), supraglótico e hipofaríngeo debutan tarde con adenopatías.
- Banderas rojas: disfonía >3 semanas en mayor de 40 años fumador, disfagia, odinofagia, otalgia refleja, hemoptisis, estridor o adenopatía cervical.
- Toda disfonía persistente >3 semanas requiere visualización laríngea (laringoscopía) por especialista.
- Hipofaringe (seno piriforme): disfagia progresiva, otalgia refleja y masa cervical; diagnóstico tardío y peor pronóstico.
- Manejo inicial: cese de tabaco; si hay estridor o disnea, asegurar vía aérea. Derivar a otorrinolaringología para biopsia y TAC cervical.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 58

Un paciente de 61 años, fumador, consulta por disfonía de 2 meses de evolución, asociada a la aparición de una adenopatía cervical de consistencia aumentada. **¿Cuál es el examen inicial para el estudio de este paciente?**

A Radiografías de cuello
B Endoscopía digestiva alta
C Nasofibroscopía
D Ecografía de cuello
E TAC de cuello

Respuesta C. La disfonía crónica se estudia con nasofibroscopía, más aún cuando se sospecha un cáncer de laringe, como en este fumador con adenopatía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 7

Un paciente de 66 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por otalgia derecha, de algunos meses de evolución, asociado a odinofagia y disfagia, a lo que se le ha agregado atoramiento con algunos alimentos y cambios en la resonancia de la voz. **El diagnóstico más probable es:**

A Cáncer de esófago
B Disfunción temporomandibular
C Cáncer de hipofaringe
D Faringitis crónica
E Cáncer de laringe

Respuesta C. Es un cáncer de hipofaringe clásico. El cáncer de laringe suele presentar disfonía progresiva, sin los otros síntomas, y el cáncer de esófago presenta disfagia sin los otros síntomas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 2

Un paciente de 58 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disfonía de 3 semanas de evolución, asociada a ligera odinofagia. Al examen físico, además, se palpa una adenopatía submandibular, de consistencia aumentada. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A TAC de cuello
B TAC de tórax
C Ecografía de cuello
D Nasofibrolaringoscopía
E Endoscopía digestiva alta

Respuesta D. Toda disfonía crónica se estudia con nasofibrolaringoscopía. Además, el cuadro sugiere un cáncer de laringe, así que con mayor razón está indicada.

▶ VER CLASE 6.03.1.006 Cáncer nasosinusal

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.20 · Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumores raros; ocupacionales (polvo de madera: adenocarcinoma etmoidal; níquel, cuero). Escamoso es el más frecuente en seno maxilar.
- Sospechar ante síntomas nasales unilaterales en adulto: obstrucción progresiva, rinorrea sanguinolenta, epistaxis recurrente unilateral, cacosmia.
- Signos de extensión: proptosis, diplopía, epífora, hipoestesia infraorbitaria, dolor dental o aflojamiento de piezas, masa en paladar.
- Diferencial: pólipo antrocoanal, papiloma invertido, cuerpo extraño (niño). Unilateralidad persistente en adulto es la clave de alarma.
- Derivar a otorrinolaringología para nasofibroscopía, TAC/RM y biopsia; no tratar como sinusitis repetida.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 62 años, carpintero por 40 años, con obstrucción nasal izquierda progresiva de 4 meses, epistaxis unilateral recurrente, rinorrea fétida y parestesia de la mejilla izquierda. La rinoscopía muestra una masa friable en la fosa nasal izquierda. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Corticoide nasal y control en 3 meses
B Antibiótico por sinusitis bacteriana
C Cauterización de la epistaxis y alta
D Derivación prioritaria a otorrinolaringología para TAC o RM de cavidades paranasales y biopsia por sospecha de cáncer nasosinusal
E Polipectomía en atención primaria

Respuesta D. Síntomas nasales unilaterales y progresivos (obstrucción, epistaxis, rinorrea fétida) con signos de invasión (hipoestesia del infraorbitario, diplopía, proptosis) en un adulto mayor son banderas rojas de cáncer nasosinusal. La exposición a polvo de madera se asocia a adenocarcinoma etmoidal. Requiere imagen y biopsia. Los pólipos inflamatorios suelen ser bilaterales.

▶ VER CLASE 6.03.1.007 Diagnóstico diferencial de hipoacusias de transmisión

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.5 · Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipoacusia de conducción: Rinne negativo (VO>VA) en oído afectado y Weber lateralizado hacia el oído enfermo.
- Causas: tapón de cerumen, cuerpo extraño, otitis externa, otitis media con efusión, perforación timpánica, colesteatoma, otoesclerosis.
- Otoscopía orienta: conducto ocupado, tímpano retraído/opaco con nivel, perforación o tímpano normal (otoesclerosis: mujer joven, progresiva, antecedente familiar).
- Audiometría: gap aéreo-óseo; impedanciometría: curva B (efusión), C (disfunción tubaria), As (otoesclerosis).
- Manejo inicial: resolver tapón de cerumen o tratar otitis; derivar a otorrinolaringología si persiste, hay perforación, colesteatoma o tímpano normal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 35

Una paciente de 48 años consulta por hipoacusia bilateral de 10 años de evolución, progresiva, que aumentó especialmente durante su último embarazo. Su otoscopía es normal y el examen neurológico no muestra alteraciones vestibulares ni cerebelosas. Se realiza test de diapasones, que muestra prueba de Rinne negativo bilateral y prueba de Weber que no lateraliza. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hipoacusia genética neurosensorial

B Ototoxicidad

C Otoesclerosis

D Hipoacusia hormonal

E Otitis media con efusión

Respuesta C. El Rinne negativo habla de hipoacusia de conducción, y el Weber no lateraliza porque es bilateral y simétrica. Con otoscopía normal, curso lento de diez años y empeoramiento en el embarazo, es otoesclerosis. La otitis con efusión también es de conducción, pero se vería en la otoscopía.

▶ VER CLASE 6.03.1.008 Diagnóstico diferencial de hipoacusias sensorioneurales

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.5 · Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)
Otorrino 14.6 · Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipoacusia sensorioneural: Rinne positivo (VA>VO) y Weber lateralizado al oído sano; audiometría con vía aérea y ósea descendidas juntas.
- Causas: presbiacusia (bilateral, simétrica, agudos), trauma acústico (escotoma en 4 kHz), ototóxicos, Ménière, sordera súbita, neurinoma del acústico.
- Hipoacusia unilateral asimétrica con tinnitus: descartar neurinoma del VIII par con resonancia magnética.
- Sordera súbita (<72 h) es urgencia: prednisona 1 mg/kg/día y derivación inmediata.
- GES: hipoacusia bilateral en ≥65 años con audífono; tratamiento de hipoacusia en prematuros. Derivar a ORL para audiometría y estudio.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 72 años consulta porque desde hace 3 años presenta dificultad para entender las conversaciones cuando asiste a reuniones familiares o en lugares con ruido de fondo, refiriendo que "oye pero no entiende". No tiene otalgia ni vértigo. La audiometría demuestra una hipoacusia sensorioneural bilateral y simétrica, con mayor caída en los tonos agudos (3000 a 8000 Hz) y caída de la discriminación de la palabra al 60%. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el beneficio en el sistema de salud chileno?**

A Otoesclerosis bilateral; resolución quirúrgica con estapedectomía GES

B Presbiacusia; patología con Garantía Explícita en Salud (GES) con indicación de audífonos bilaterales

C Enfermedad de Ménière bilateral; tratamiento con restricción de sal y acetazolamida

D Trauma acústico crónico; derivación a mutualidad de seguridad laboral para indemnización

E Neurinoma del acústico bilateral; estudio genético urgente para Neurofibromatosis tipo 1

Respuesta B. Es presbiacusia: hipoacusia sensorioneural bilateral, simétrica, en agudos, con mala discriminación en ambientes ruidosos. En Chile, la hipoacusia en personas de 65 años y más tiene GES, con confirmación diagnóstica, audífonos y rehabilitación.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 55 años consulta por hipoacusia del oído izquierdo de 2 semanas, sin dolor ni secreción. La otoscopía es normal en ambos oídos. Con el diapasón de 512 Hz, el Weber lateraliza hacia el oído derecho y el Rinne es positivo en ambos oídos. **¿Qué tipo de hipoacusia tiene y cómo la confirmarías?**

A Hipoacusia de conducción izquierda; timpanometría

B Hipoacusia de conducción derecha; audiometría

C Hipoacusia sensorioneural izquierda; audiometría tonal

D Audición normal; control en un mes

E Tapón de cerumen izquierdo; lavado de oído

Respuesta C. El Weber se va al oído derecho, el sano, y el Rinne es positivo en ambos lados: es una hipoacusia sensorioneural del oído izquierdo. Se confirma con audiometría tonal, que debe mostrar ambas curvas descendidas sin brecha. Una hipoacusia de conducción izquierda daría Weber al izquierdo y Rinne negativo en ese oído.

▶ VER CLASE 6.03.1.009 Disfonías agudas

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.16 · Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke

QUÉ HAY QUE SABER

- Disfonía aguda (<3 semanas): laringitis viral asociada a resfrío es la causa más frecuente; también abuso vocal agudo.
- Tratamiento: reposo vocal, hidratación, humidificación, evitar tabaco e irritantes; analgesia. Antibióticos no indicados.
- Considerar reflujo laringofaríngeo (carraspeo, globus): IBP por 8 semanas y medidas antirreflujo.
- Banderas rojas: estridor, disnea, disfagia, hemoptisis, fumador mayor de 40 o persistencia >3 semanas: derivar para laringoscopía.
- Disfonía postquirúrgica (tiroidectomía) o tras intubación sugiere lesión del nervio laríngeo recurrente o trauma: evaluar por ORL.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 149

Una paciente de 27 años sufre atoro con un pedazo de alimento hace 7 días, que obstruyó la vía aérea y requirió maniobra de Heimlich para su desobstrucción. Desde entonces ha persistido con disfonía y carraspera. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar endoscopía digestiva alta

B Solicitar radiografías de cuello

C Solicitar TAC de cuello

D Solicitar nasofibrolaringoscopía

E Solicitar videodeglución

Respuesta D. Toda disfonía persistente se evalúa con nasofibrolaringoscopía. Además, el antecedente de cuerpo extraño y maniobra de Heimlich hace sospechar una lesión laríngea, una parálisis cordal o un cuerpo extraño residual, que se objetivan con este examen.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 149

Paciente de 27 años sufrió atoro con un trozo de alimento hace 7 días, que obstruyó la vía aérea y requirió maniobra de Heimlich para su desobstrucción. Desde entonces ha persistido con disfonía y carraspera. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar endoscopía digestiva alta

B Solicitar radiografías de cuello

C Solicitar TAC de cuello

D Solicitar nasofibrolaringoscopía

E Solicitar videodeglución

Respuesta D. Una disfonía que persiste tras un evento laríngeo (cuerpo extraño, maniobras de desobstrucción, intubación) puede deberse a lesión de cuerdas vocales, hematoma, restos de cuerpo extraño o luxación aritenoidea. El examen de elección es la visualización directa de la laringe mediante nasofibrolaringoscopía. Las imágenes y la endoscopía digestiva no evalúan la movilidad cordal.

▶ VER CLASE 6.03.1.010 Disfonías crónicas

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.16 · Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke

QUÉ HAY QUE SABER

- Disfonía crónica: >3 semanas; obliga a visualizar la laringe para descartar cáncer, especialmente en fumadores mayores de 40 años.
- Causas: nódulos vocales (bilaterales, profesionales de la voz), pólipo, edema de Reinke (fumadora), quiste, parálisis cordal, reflujo, carcinoma.
- Parálisis de cuerda vocal: buscar lesión del recurrente (cirugía tiroidea, tumor pulmonar o mediastínico, aneurisma aórtico).
- Manejo inicial: suspender tabaco, higiene vocal, tratar reflujo; no prolongar tratamiento empírico sin laringoscopía.
- Derivar a otorrinolaringología para laringoscopía; nódulos se manejan con fonoaudiología, pólipos y lesiones sospechosas con cirugía/biopsia.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 103

Un paciente de 30 años presenta disfonía persistente, de un mes de evolución, que inició al asistir a un concierto de rock. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Nódulos vocales
B Disfonía musculotensional
C Cáncer de laringe
D Pólipos vocales
E Reflujo faringo-laríngeo

Respuesta D. Los pólipos pueden producirse de forma aguda: al forzar mucho la voz hay una hemorragia en la cuerda que evoluciona a un pólipo. Los nódulos y la disfonía musculotensional se forman por abuso vocal crónico. A los treinta años el cáncer de laringe es muy improbable.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una profesora de 32 años consulta por disfonía de 3 meses que empeora al final de la semana laboral. Tiene fatiga vocal y voz soplada. No fuma. En la nasofibroscopía se ven dos lesiones blanquecinas pequeñas, simétricas y enfrentadas, en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores del borde libre de ambas cuerdas. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A Microcirugía laríngea con láser inmediata
B Rehabilitación fonoaudiológica e higiene vocal
C Corticoides orales en dosis altas por 21 días
D Toxina botulínica en el músculo tiroaritenoideo
E Reposo vocal absoluto por 6 meses

Respuesta B. Son nódulos vocales bilaterales por abuso vocal. El tratamiento de primera línea es la rehabilitación fonoaudiológica. La cirugía inicial está desaconsejada, porque recidiva si no se corrige la técnica de emisión.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 2

Un paciente de 58 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disfonía de 3 semanas de evolución, asociada a ligera odinofagia. Al examen físico, además, se palpa una adenopatía submandibular, de consistencia aumentada. ¿Cuál es el examen más adecuada para proseguir el estudio?

A TAC de cuello
B TAC de tórax
C Ecografía de cuello
D Nasofibrolaringoscopía
E Endoscopía digestiva alta

Respuesta D. Toda disfonía crónica se estudia con NFC. En este caso, además, el cuadro clínico sugiere cáncer de laringe, así que con mayor razón está indicada la NFC.

▶ VER CLASE 6.03.1.011 Epistaxis a repetición

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.11 · Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

QUÉ HAY QUE SABER

- Epistaxis recurrente: generalmente anterior en área de Kiesselbach; en niños por manipulación digital, rinitis y sequedad.
- Buscar causas: HTA, anticoagulantes/antiagregantes, coagulopatía (von Willebrand), telangiectasia hemorrágica hereditaria, tumor (nasoangiofibroma en adolescente varón).
- Manejo: compresión digital 10-15 minutos, vasoconstrictor tópico, cauterización química con nitrato de plata del punto sangrante, lubricación nasal.
- Solicitar hemograma y pruebas de coagulación si es recurrente o hay sangrado en otros sitios.
- Derivar a ORL si es unilateral persistente, adolescente varón con obstrucción nasal, sospecha tumoral o falla de cauterización.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 9 años con episodios de epistaxis anterior derecha 2 a 3 veces por semana en el último mes, autolimitados con compresión, especialmente en invierno. Se rasca la nariz con frecuencia. Al examen hay vasos prominentes y costras en el área de Kiesselbach derecha. Sin hematomas ni otros sangrados, hemograma normal. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Taponamiento posterior
B Humectación nasal (vaselina o suero), evitar el rascado y cauterización química con nitrato de plata del área de Kiesselbach si persiste
C Estudio de coagulación completo y derivación a hematología de inmediato
D Ligadura de la arteria esfenopalatina
E TAC de cavidades paranasales

Respuesta B. La epistaxis recurrente anterior en niños se origina en el plexo de Kiesselbach, favorecida por sequedad, rascado y rinitis. Se maneja con humectación, tratamiento de la rinitis y cauterización con nitrato de plata de los vasos visibles. Se estudia coagulación ante sangrados en otros sitios, antecedentes familiares o anemia; en un adolescente varón con epistaxis unilateral grave, sospechar nasoangiofibroma.

▶ VER CLASE 6.03.1.012 Epistaxis leve

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.11 · Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

QUÉ HAY QUE SABER

- Epistaxis leve: 90% anterior (plexo de Kiesselbach), autolimitada; más frecuente en niños y con aire seco.
- Primer paso: paciente sentado, cabeza inclinada hacia adelante, compresión bidigital de alas nasales 10-15 minutos sin soltar.
- Si persiste: algodón con vasoconstrictor (oximetazolina) y anestésico, luego cauterización con nitrato de plata; si falla, taponamiento anterior.
- Evaluar estabilidad hemodinámica y presión arterial; no inclinar la cabeza hacia atrás (deglución de sangre y aspiración).
- Prevención: lubricación con vaselina o suero, evitar manipulación digital; derivar si es recurrente o no cede.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 9 años consulta en urgencia por sangrado nasal derecho activo tras hurgarse la nariz. Está hemodinámicamente estable. Se realiza compresión bimanual de las alas nasales durante 15 minutos continuos con cabeza hacia adelante, pero al soltar persiste sangrado leve. Al colocar un algodón con vasoconstrictor y retirarlo bajo buena luz con espéculo nasal, se visualiza claramente un vaso sangrante superficial en la porción anteroinferior del tabique nasal derecho. **¿Cuál es la conducta terapéutica de elección a continuación?**

A Realizar taponamiento nasal posterior con sonda Foley de urgencia.

B Cauterización química del vaso sangrante con bastón de nitrato de plata.

C Indicar ácido tranexámico endovenoso y hospitalizar para observación.

D Cauterización bilateral simultánea de ambas caras del tabique nasal.

E Indicar al paciente mantener la cabeza inclinada hacia atrás durante las próximas 4 horas.

Respuesta B. Con el vaso identificado en el plexo de Kiesselbach, tras compresión y vasoconstrictor, corresponde cauterizar con nitrato de plata, de forma suave y concéntrica. Cauterizar ambos lados causa necrosis y perforación septal; la cabeza hacia atrás induce deglución de sangre; el taponamiento posterior y la hospitalización son desproporcionados.

▶ VER CLASE 6.03.1.013 Estridor laríngeo

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.17 · Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Estridor: ruido por obstrucción de vía aérea; inspiratorio sugiere supraglotis/glotis, bifásico subglotis, espiratorio tráquea intratorácica.
- Lactante con estridor inspiratorio que empeora en decúbito supino y llanto, desde las primeras semanas: laringomalacia (causa más frecuente, benigna).
- Agudo: laringitis obstructiva (crup, tos perruna; dexametasona 0,15-0,6 mg/kg y adrenalina nebulizada si moderado-severo), cuerpo extraño, epiglotitis, angioedema.
- Signos de gravedad: retracción, cianosis, alteración de conciencia, sialorrea, posición en trípode; no explorar faringe si se sospecha epiglotitis.
- Derivar a ORL/broncopulmonar para nasofibroscopía si es crónico, progresivo, con mal incremento ponderal, apneas o cianosis.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 86

Lactante con estridor desde el nacimiento, cuya causa es una laringomalacia. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Control sano habitual

B Derivar a especialista

C Hospitalizar

D Observación domiciliaria

E Iniciar tratamiento empírico

Respuesta A. La laringomalacia es la causa más frecuente de estridor congénito: estridor inspiratorio que aumenta en decúbito supino y con el llanto. En las formas leves, sin apneas, cianosis ni mal incremento ponderal, se maneja en el control sano habitual, porque se resuelve sola hacia los 12 a 18 meses.

▶ VER CLASE 6.03.1.014 Hipoacusia neonatal

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.21 · Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Factores de riesgo: prematurez, UCI neonatal >5 días, hiperbilirrubinemia, TORCH (CMV), ototóxicos, malformaciones craneofaciales, antecedente familiar.
- Tamizaje universal con emisiones otoacústicas (o PEAT automatizado en riesgo) antes del alta; GES: hipoacusia bilateral del prematuro.
- Si falla, repetir; si falla nuevamente, potenciales evocados auditivos de tronco (PEAT) para confirmar antes de los 3 meses.
- Meta 1-3-6: tamizaje al mes, diagnóstico a los 3 meses, intervención (audífonos/implante coclear) antes de los 6 meses.
- Sospecha clínica: no reacciona a ruidos, no balbucea o retraso del lenguaje; derivar a ORL infantil ante tamizaje alterado.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 92

Lactante que llega sin test de audición a su primer control. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Emisiones otoacústicas
B Impedanciometría
C Evaluación por fonoaudiología
D Audiometría
E Reflejo cocleopalpebral

Respuesta A. El examen de tamizaje auditivo universal en el recién nacido es la medición de emisiones otoacústicas. Los potenciales evocados quedan para cuando esta prueba sale alterada, no como primera opción.

▶ VER CLASE 6.03.1.015 Masa cervical

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.20 · Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

QUÉ HAY QUE SABER

- Niño: generalmente inflamatoria (adenitis reactiva) o congénita (quiste tirogloso en línea media que asciende con la lengua, quiste branquial lateral).
- Adulto >40 años: masa cervical persistente >2-3 semanas es neoplasia (metástasis de carcinoma escamoso, linfoma, tiroides) hasta demostrar lo contrario.
- Banderas rojas: dura, fija, indolora, >2 cm, supraclavicular, crecimiento progresivo, síntomas B, disfonía, disfagia u otalgia refleja.
- Manejo inicial: si es inflamatoria, antibiótico y control en 2-3 semanas; no repetir ciclos antibióticos indefinidamente.
- Derivar a ORL/cabeza y cuello: nasofibroscopía, ecografía o TAC y PAAF; evitar biopsia excisional antes de examinar vía aerodigestiva.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 92

Un paciente de 18 años consulta por odinofagia intensa de 2 días asociada a fiebre hasta 38,5 °C y aumento de volumen doloroso submandibular derecho. Tiene faringe congestiva con amígdala derecha aumentada y exudado purulento. Se palpa una masa blanda y dolorosa, con eritema, de 4 cm en la zona submandibular derecha. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Absceso periamigdalino
B Mononucleosis infecciosa
C Quiste branquial infectado
D Adenitis supurada
E Linfoma de Hodgkin

Respuesta D. Es una amigdalitis bacteriana complicada con una adenitis supurada submandibular. El absceso periamigdalino se caracteriza por dolor muy intenso, trismus y abombamiento del pilar amigdalino, que aquí no aparecen.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 62 años, fumador crónico, consulta por una masa en la región lateral izquierda del cuello de 4 semanas de evolución, indolora y pétrea, de 3 cm. Refiere además otalgia refleja izquierda ocasional con otoscopía normal. **¿Cuál es el método de elección para la confirmación anatomopatológica y cuál procedimiento está formalmente contraindicado?**

A Elección: biopsia incisional abierta en pabellón. Contraindicada: PAAF bajo ecografía
B Elección: PAAF guiada por ecografía. Contraindicada: biopsia ganglionar abierta antes de descartar un tumor primario en la vía aérea superior
C Elección: aspiración con trócar grueso por sospecha de quiste sebáceo. Contraindicada: tomografía computarizada
D Elección: exéresis de urgencia de la glándula tiroides. Contraindicada: nasofibroscopía flexible
E Elección: cefadroxilo oral por 21 días. Contraindicada: evaluación por otorrinolaringólogo

Respuesta B. En un fumador mayor de 40 años, una masa cervical pétrea es una metástasis de carcinoma escamoso hasta demostrar lo contrario. La PAAF guiada por ecografía es el método citológico de primera línea y no disemina células. Está prohibida la biopsia abierta del ganglio sin evaluar antes la vía aérea superior y sin PAAF.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 58 años, fumador de 30 cigarrillos al día por 35 años y bebedor diario de vino, consulta por un aumento de volumen indoloro en la región lateral derecha del cuello, de 1 mes y creciente. Desde hace 3 semanas tiene un dolor punzante en el oído derecho al tragar, sin secreción ni sordera. Se palpa una masa de 3,5 cm en el nivel II derecho, pétrea, adherida a planos profundos e indolora. La otoscopía de ambos oídos es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Biopsia excisional del ganglio en pabellón
B Ciclo de cefadroxilo oral por 21 días y control
C Nasofibroscopía para buscar el tumor primario y PAAF guiada por ecografía
D Drenaje de la masa pensando en un quiste sebáceo
E Observar y reevaluar en 3 meses

Respuesta C. Masa pétrea y fija en un fumador mayor de 40 años, más otalgia refleja con otoscopía normal: metástasis de un carcinoma escamoso de la vía aerodigestiva superior hasta demostrar lo contrario. Se hace examen ORL con nasofibroscopía y PAAF guiada por ecografía, y luego TAC para etapificar. Está prohibida la biopsia abierta sin estudio previo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 31

Una paciente de 35 años, que cursa una infección respiratoria alta, presenta aparición de aumento de volumen cervical progresivo, de localización suprahioidea. A la palpación, se constata consistencia gomosa y se observa que asciende al solicitarle a la paciente que protruya la lengua. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Nódulo 2roideo
B Quiste dermoide
C Adenopaaa cervical
D Quiste del conducto 2rogloso
E Linfoma

Respuesta D. Es un quiste del conducto Grogloso clásico. La ubicación en la línea media, suprahioidea es lo más característico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 75

Un paciente de 23 años consulta por aumento de volumen en el cuello, que ha aumentado lentamente de tamaño en los últimos meses. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, en la línea media, ubicado entre el mentón y el cartílago tiroides, de 3 cm de diámetro y consistencia blanda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Quiste branquial
B Adenitis supurada
C Quiste del conducto tirogloso
D Adenoma de glándula salival submandubilar
E Quiste epidermoide

Respuesta D. Diagnóstico: Adenoma de glándula salival submandubilar (opción D).

▶ VER CLASE 6.03.1.016 Obstrucción nasal crónica

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.12 · Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal

QUÉ HAY QUE SABER

- Causas: desviación septal, hipertrofia de cornetes, rinitis alérgica/medicamentosa, pólipos, hipertrofia adenoidea (niño) y tumores.
- Unilateral: desviación septal, pólipo antrocoanal, cuerpo extraño (niño, rinorrea fétida) o tumor; bilateral: rinitis, poliposis, adenoides.
- Rinitis medicamentosa por uso de vasoconstrictor tópico >5-7 días: suspender y usar corticoide intranasal.
- Manejo inicial: corticoide intranasal y lavados salinos si hay componente inflamatorio; tratar la rinitis alérgica de base.
- Derivar a ORL si persiste pese a tratamiento, es unilateral, hay sangrado o sospecha anatómica (septoplastía, adenoidectomía).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 32 años consulta por obstrucción nasal derecha constante de varios años, que no fluctúa, sin estornudos, prurito ni rinorrea. En la adolescencia tuvo un golpe en la nariz. A la rinoscopía anterior, el tabique está desviado hacia la derecha y contacta el cornete inferior; en la fosa izquierda hay hipertrofia del cornete inferior. No hay pólipos. **¿Cuál es el tratamiento definitivo?**

A Oximetazolina nasal diaria
B Septoplastia electiva, con turbinoplastia del cornete hipertrófico
C Polipectomía endoscópica
D Antihistamínicos orales por 3 meses
E Amoxicilina con ácido clavulánico por 14 días

Respuesta B. Obstrucción unilateral, fija y constante tras un trauma, con tabique desviado, es una desviación septal. Los corticoides intranasales alivian el componente mucoso, pero la corrección definitiva es la septoplastia electiva, asociando turbinoplastia del cornete compensatorio. Los descongestionantes de uso crónico producen rinitis medicamentosa.

▶ VER CLASE 6.03.1.017 Odinofagias agudas

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.13 · Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

QUÉ HAY QUE SABER

- Odinofagia aguda: casi siempre faringoamigdalitis, mayoritariamente viral; considerar S. pyogenes si fiebre, exudado, adenopatías anteriores y ausencia de tos.
- Tratamiento bacteriana: penicilina benzatina 1.200.000 UI IM única o amoxicilina 50 mg/kg/día por 10 días; viral: sintomático.
- Otras causas: mononucleosis, herpangina (vesículas en paladar blando), candidiasis, esofagitis (odinofagia retroesternal en inmunodeprimido).
- Banderas rojas: trismus, sialorrea, voz apagada, desviación de úvula, tortícolis o disnea: absceso periamigdalino, retrofaríngeo o epiglotitis.
- Control si no mejora en 48-72 horas; derivar ante sospecha de absceso o compromiso de vía aérea.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 24 años consulta por odinofagia de 2 días, con temperatura de 37,8 °C, rinorrea, tos, disfonía y conjuntivas enrojecidas. Al examen tiene faringe eritematosa sin exudado y no hay adenopatías cervicales dolorosas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Amoxicilina oral por 10 días

B Penicilina benzatina intramuscular

C Tratamiento sintomático, hidratación y consulta si aparecen signos de alarma

D Hemograma y serología para virus Epstein-Barr

E Azitromicina oral por 5 días

Respuesta C. La mayoría de las odinofagias agudas son virales. Tos, rinorrea, disfonía y conjuntivitis orientan a virus, y con McIsaac de 0 no se estudia ni se dan antibióticos: solo sintomáticos. Se educa en signos de alarma: trismus, sialorrea, voz apagada, disnea o fiebre que persiste más de 3 a 5 días.

▶ VER CLASE 6.03.1.018 Odinofagias crónicas

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.20 · Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

QUÉ HAY QUE SABER

- Odinofagia >3 semanas en adulto, sobre todo fumador y bebedor, debe hacer sospechar cáncer de orofaringe, hipofaringe o laringe supraglótica.
- Asociar: otalgia refleja, disfagia, baja de peso, halitosis, adenopatía cervical o úlcera que no cura.
- Otras causas: reflujo laringofaríngeo, amigdalitis crónica, candidiasis, esofagitis infecciosa o por fármacos, tiroiditis subaguda.
- No prolongar tratamientos antibióticos empíricos; manejo inicial sintomático y suspensión de tabaco y alcohol.
- Derivar a ORL para nasofibroscopía y eventual biopsia; si hay disfagia esofágica, endoscopía digestiva alta.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 60 años, fumador de 40 paquetes-año y bebedor intenso, con odinofagia derecha de 2 meses, otalgia refleja derecha y baja de 6 kg de peso. No tiene fiebre. Se palpa una adenopatía cervical derecha dura de 3 cm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Amoxicilina por 10 días y control

B Ecografía tiroidea

C Inhibidor de bomba de protones por reflujo

D Antiinflamatorios y control en 3 meses

E Derivación prioritaria a otorrinolaringología para nasofibrolaringoscopía y biopsia por sospecha de cáncer de orofaringe, hipofaringe o laringe

Respuesta E. La odinofagia persistente (más de 3 semanas), unilateral, con otalgia refleja, baja de peso y adenopatía cervical dura en un fumador y bebedor es un carcinoma escamoso de cabeza y cuello hasta demostrar lo contrario. Requiere examen endoscópico, biopsia de la lesión primaria y TAC cervical con contraste. No se debe tratar empíricamente con antibióticos de forma reiterada.

▶ VER CLASE 6.03.1.019 Otitis externa

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.3 · Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Otitis externa difusa: P. aeruginosa y S. aureus; otalgia intensa que aumenta con tracción del pabellón o presión del trago, otorrea, conducto edematoso.
- Factores: humedad ("oído de nadador"), manipulación con cotonitos, audífonos, dermatitis.
- Tratamiento: gotas de ciprofloxacino con corticoide (dexametasona/hidrocortisona) por 7-10 días, analgesia y mantener oído seco; aseo del conducto.
- Otomicosis (Aspergillus, Candida): prurito, detritus con esporas; aseo y antifúngico tópico (clotrimazol).
- Otitis externa maligna: diabético o inmunodeprimido, otalgia nocturna intensa, granulación en conducto, parálisis facial: hospitalizar, TAC y antibiótico EV antipseudomonas; derivar.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 160

Un niño de 6 años presenta prurito en el oído derecho desde hace 3 días, al que ayer se agregó otalgia intensa. Al examen físico, presenta dolor intenso a la compresión del trago y, en la otoscopía, se observa edema del conducto auditivo y presencia de secreción amarillenta. El tímpano se observa sin perforación, de aspecto grisáceo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Forunculosis del conducto auditivo externo

B Otitis externa

C Otitis media aguda

D Colesteatoma

E Candidiasis del oído

Respuesta B. Otitis externa clásica, de tipo difuso, probablemente por Pseudomonas aeruginosa. Se trata con ciprofloxacino tópico. La otomicosis por Candida produce prurito, con poco dolor y secreción grumosa blanquecina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 170

Un niño de 9 años presenta otalgia de dos días de evolución, con secreción por el conducto auditivo, sin mal olor. Al examen físico se aprecia dolor a la tracción del pabellón auricular, con conducto auditivo estrecho, que dificulta la otoscopía, siendo imposible visualizar el tímpano. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Otitis externa
B Tapón de cerumen
C Otitis media crónica
D Cuerpo extraño ótico
E Otitis media aguda perforada

Respuesta A. El dolor a la tracción del pabellón sugiere otitis externa. No suele haber mal olor, porque Pseudomonas no lo produce, y un conducto estrecho es factor de riesgo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 46

Un paciente de 35 años consulta por otalgia izquierda de 3 días de evolución, asociada a otorrea ipsilateral. El dolor aumenta al traccionar el pabellón auricular. A la otoscopía se observa el conducto auditivo externo edematoso, con escasa secreción y tímpano normal. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A Amoxicilina oral
B Ciprofloxacino tópico
C Amoxicilina más ácido clavulánico oral
D Neomicina tópica
E Antiinflamatorios orales

Respuesta B. Otitis externa difusa: primera línea ciprofloxacino tópico. La neomicina también tiene evidencia con el tímpano intacto, y solo está contraindicada si hay perforación, por ototoxicidad; la pregunta se resolvió a favor del ciprofloxacino.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 157

Un paciente de 35 años consulta por prurito en el oído izquierdo, asociado a secreción blanquecina y sensación de oído tapado. A la otoscopía se observa abundante secreción grumosa que cubre parcialmente el tímpano. **¿Cuál es el tratamiento de elección para iniciar el manejo de este paciente?**

A Ciprofloxacino tópico
B Fluconazol oral
C Clotrimazol tópico
D Amoxicilina oral
E Ciprofloxacino oral

Respuesta C. Otomicosis por Candida albicans: se trata con un antimicótico tópico, como clotrimazol.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 78 años, diabética de larga data con mal apego al tratamiento, consulta por otalgia derecha intensa de predominio nocturno, refractaria a paracetamol y tramadol, con otorrea purulenta fétida. En la otoscopía hay edema del conducto con tejido de granulación eritematoso en el piso, en la unión osteocartilaginosa. Presenta desviación de la comisura bucal hacia la izquierda y lagoftalmos derecho. **¿Cuál es el examen inicial de elección para evaluar la extensión ósea?**

A Radiografía simple de cráneo en proyección de Schüller
B TAC de peñasco y base de cráneo con contraste
C Resonancia magnética de encéfalo sin contraste
D Ecografía de partes blandas de la región parotídea
E Audiometría y potenciales evocados auditivos de tronco

Respuesta B. Otitis externa maligna con parálisis del VII par. El TAC de peñasco y base de cráneo con contraste define la osteólisis. La radiografía simple tiene poca resolución, y la resonancia complementa después las partes blandas endocraneales.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 102

Un niño de 7 años presenta otalgia derecha, asociada a otorrea. Al examinarlo presenta otorrea, sin olor y a la otoscopía presenta canal auditivo estrecho, por lo que no es posible ver el tímpano. Además presenta dolor al traccionar el pabellón auricular. EL diagnóstico más probable es:

A Otitis media aguda
B Otitis media crónica
C Otitis externa
D Tapón de cerumen
E Otomastoiditis aguda

Respuesta C. Diagnóstico: Otitis externa (opción C). Cuadro clásico (aunque pudieron haberlo descrito mejor).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 167

Una paciente se pone un piercing en la oreja, sin embargo evoluciona con dolor y eritema, por lo que se la retira. Al sacar el piercing no ha mejorado y, en cambio, el pabellón auricular se observa eritematoso y aumentado de volumen, como se ve en la siguiente imagen (fuente:): ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A Streptococcus pyogenes
B Staphylococcus aureus
C Streptococcus agalactiae
D Staphylococcus epidirmidis
E Pseudomona aureginosa

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Pseudomona aureginosa).

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 113

Paciente con piercing en oreja; al retirarlo persiste aumento de volumen y eritema en la zona. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A Pseudomonas aeruginosa
B Staphylococcus aureus
C Streptococcus pyogenes
D Candida albicans
E Mycobacterium fortuitum

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Pseudomonas aeruginosa). Pseudomonas aeruginosa.

▶ VER CLASE 6.03.1.020 Otitis media aguda

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.1 · Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico: otalgia/fiebre aguda más tímpano abombado, eritematoso, opaco e inmóvil a la otoscopía neumática; agentes: neumococo, H. influenzae, M. catarrhalis.
- Tratamiento: amoxicilina 80-90 mg/kg/día cada 12 horas, 10 días si <2 años o severa (5-7 días en mayores), más paracetamol o ibuprofeno.
- Si no mejora en 48-72 horas: cambiar a amoxicilina-ácido clavulánico; alérgicos: macrólido (claritromicina o azitromicina).
- OMA perforada: otorrea purulenta con alivio del dolor; mismo antibiótico oral, mantener oído seco; puede agregarse gota de ciprofloxacino.
- Banderas rojas: retroauricular eritematoso, pabellón desplazado, parálisis facial, cefalea, vértigo o meningismo: complicación, derivar urgente.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 18 meses, previamente sano y con vacunas al día, consulta por fiebre de 39,2 °C axilar de 24 horas, llanto inconsolable y manos hacia la oreja derecha. Tuvo un resfrío común hace 5 días en la sala cuna. Está febril, reactivo y sin signos meníngeos. La otoscopía izquierda es normal; en el oído derecho el tímpano está francamente abombado, eritematoso, opaco y sin movilidad, sin otorrea. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Amoxicilina 80 a 90 mg/kg/día cada 12 horas por 10 días y analgesia con paracetamol o ibuprofeno
B Gotas óticas de ciprofloxacino con corticoide por 7 días
C Solo analgesia y observación por 48 horas, sin antibióticos
D Antihistamínico y descongestionante nasal por 7 días
E Derivación urgente para miringotomía y timpanocentesis

Respuesta A. Es una OMA severa: menor de 2 años, fiebre sobre 39 °C y tímpano abombado con hipomovilidad. Corresponde amoxicilina en dosis alta por 10 días más analgesia. Las gotas óticas no atraviesan un tímpano íntegro, los antihistamínicos no sirven, y la miringotomía se reserva para las complicaciones.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 128

Niño con antecedente de resfrío de 1 semana que inicia con otorrea y otalgia, a la otoscopia secreción purulenta, no se visualiza tímpano:

A Amoxicilina
B Amoxicilina/ Ac. clavulánico
C Ciprofloxacino tópico
D Control sano habitual
E Derivar a especialista

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Amoxicilina). La otitis media aguda es una infección bacteriana del oído medio muy frecuente en niños y menos frecuente en adultos.

▶ VER CLASE 6.03.1.021 Otitis media con efusión

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.2 · Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Efusión en oído medio sin signos de infección aguda; frecuente tras OMA o con disfunción tubaria/hipertrofia adenoidea. Se manifiesta como hipoacusia de conducción.
- Otoscopía: tímpano opaco, retraído, con nivel hidroaéreo o burbujas; impedanciometría con curva tipo B.
- No indicar antibióticos, corticoides, antihistamínicos ni descongestionantes; observar 3 meses (12 semanas), la mayoría se resuelve espontáneamente.
- Derivar a ORL si persiste >3 meses, hipoacusia significativa, retraso del lenguaje o cambios estructurales del tímpano: colleras ± adenoidectomía.
- Adulto con efusión unilateral persistente: descartar tumor de nasofaringe (cavum) con nasofibroscopía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un escolar de 6 años es evaluado por sospecha de déficit atencional, ya que en el colegio no obedece las órdenes y pide que le repitan las frases. No ha tenido otalgia ni fiebre. La otoscopía muestra tímpanos íntegros, ligeramente retraídos, amarillentos, con nivel hidroaéreo y burbujas bilaterales. La timpanometría muestra curvas tipo B bilaterales con hipoacusia de conducción de 25 dB. El cuadro está documentado por 4 meses consecutivos. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A Corticoides sistémicos orales en pulsos por 10 días

B Amoxicilina con ácido clavulánico por 21 días

C Inserción bilateral de tubos de ventilación timpánica (colleras)

D Mastoidectomía bilateral abierta

E Antihistamínicos orales y descongestionantes nasales prolongados

Respuesta C. Otitis media con efusión persistente por más de 3 meses, con hipoacusia de conducción bilateral: colleras. Los antibióticos, corticoides, antihistamínicos y descongestionantes no sirven, y la mastoidectomía es para colesteatoma o mastoiditis.

▶ VER CLASE 6.03.1.022 **Otitis media crónica y complicaciones** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Otorrino 14.2 · Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa
Otorrino 14.4 · Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis

QUÉ HAY QUE SABER

- OMC simple: perforación timpánica central con otorrea intermitente indolora; colesteatomatosa: perforación marginal/atical, otorrea fétida persistente y destructiva.
- Colesteatoma es quirúrgico: erosiona huesecillos, conducto del facial, laberinto y tegmen.
- Manejo inicial de la reagudización: aseo del conducto, gotas de ciprofloxacino (no ototóxicas, evitar aminoglucósidos), mantener oído seco.
- Complicaciones: mastoiditis, parálisis facial, laberintitis/fístula (vértigo), meningitis, absceso cerebral y trombosis del seno sigmoideo.
- Derivar a ORL: TAC de oídos sin contraste y cirugía (timpanoplastía, mastoidectomía); derivación urgente ante cualquier complicación.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 148

Un paciente de 47 años, con antecedente de perforación timpánica derecha de larga data, presenta otalgia y otorrea de dos días de evolución. Al examen físico, la otoscopía muestra la perforación timpánica conocida, con presencia de secreción amarillenta en relación al tímpano y al conducto auditivo externo. **¿Qué antibiótico es de elección para el tratamiento inicial de este paciente?**

A Neomicina tópica

B Ciprofloxacino tópico

C Amoxicilina oral

D Amoxicilina con ácido clavulánico oral

E Ceftriaxona endovenosa

Respuesta B. Otitis media crónica simple reagudizada: primera línea tópica con ciprofloxacino. La neomicina es un aminoglucósido, con riesgo de ototoxicidad con el tímpano perforado. Los antibióticos sistémicos se reservan para los casos complicados.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 153

Paciente de 45 años con otorrea crónica recurrente, hipoacusia conductiva y perforación timpánica central con colesteatoma evidenciado en TAC de oídos. **¿Cuál es el tratamiento?**

A Timpanomastoidectomía (cirugía)

B Antibióticos tópicos indefinidos

C Corticoides tópicos

D Audífonos

E Solo observar

Respuesta A. Colesteatoma: tratamiento quirúrgico obligatorio, timpanomastoidectomía, para erradicarlo y prevenir mastoiditis, meningitis y parálisis facial.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 35

Niño de 8 años con otorrea crónica serosa, hipoacusia conductiva bilateral y tímpano con perforación central. **¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A Gotas óticas de ciprofloxacino + taponamiento con algodón

B Miringoplastia electiva

C Timpanotomía de urgencia

D Audiometría y derivación a otorrinolaringología

E Antibiótico oral por 14 días

Respuesta D. Perforación timpánica crónica con hipoacusia de conducción: audiometría para cuantificar la pérdida y derivación a otorrinolaringología para evaluar la timpanoplastia. No se tapona un oído perforado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 104

Un paciente de 59 años presenta hipoacusia bilateral, asociado a otorrea, de larga data. Consulta por un cuadro de reciente inicio, de mayor hipoacusia derecha, asociada a vértigo persistente, que ha ido en aumento. Al examen se aprecia nistagmo horizontal, con fase rápida a derecha. **El diagnóstico más probable es:**

A Otomastoiditis aguda

B Laberintitis aguda

C Vértigo postural paroxístico

D Absceso cerebral

E Neuronitis vestibular

Respuesta B. Otorrea crónica con hipoacusia, más vértigo persistente y nistagmo de reciente inicio: laberintitis aguda, complicación de la otitis media crónica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 84

Un paciente de 45 años, con historia de años de evolución de hipoacusia y supuración por oído derecho, consulta por compromiso del estado general, fiebre hasta 39 °C, vértigo y secreción ótica purulenta. Al examen se aprecia nistagmus horizontal con fase rápida a izquierda, a la otoscopía solo se aprecia secreción purulenta en conducto auditivo externo, no se observa tímpano. **El tratamiento más adecuado en este caso es:**

A Antibióticos endovenosos

B Lavado ótico

C Cirugía de urgencia

D Corticoides endovenosos

E Antiinflamatorios endovenosos

Respuesta A. Laberintitis aguda con fiebre y mal estado general: lo primero es antibiótico endovenoso, igual que en la mastoiditis. La cirugía se evalúa caso a caso, por ejemplo si es secundaria a un colesteatoma. Es una pregunta discutible.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 2 años presenta fiebre de 39,3 °C, irritabilidad y tumefacción retroauricular izquierda dolorosa y eritematosa que desplaza el pabellón hacia adelante y borra el surco retroauricular. La otoscopía muestra el tímpano izquierdo abombado e hiperémico. **¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica inicial más adecuada?**

A Amoxicilina con ácido clavulánico oral por 14 días y control ambulatorio en 48 horas

B Ecografía de partes blandas y alta con antiinflamatorios

C Hospitalizar de inmediato, TAC de peñasco con contraste e iniciar ceftriaxona endovenosa

D Drenaje por punción ambulatoria y cefadroxilo oral

E Gotas óticas de ciprofloxacino y radiografía simple de cráneo

Respuesta C. Mastoiditis aguda: urgencia que exige hospitalización, TAC de peñasco con contraste y ceftriaxona endovenosa, con evaluación por otorrinolaringología. El manejo ambulatorio con antibióticos orales no corresponde.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 42 años consulta por hipoacusia progresiva izquierda y supuración ótica intermitente de larga data. En el último mes la supuración es constante y de olor muy fétido, y hace 4 días siente inestabilidad al limpiarse el oído. En la otoscopía izquierda hay una perforación marginal posterosuperior en la pars flácida, por la que asoman detritos blanquecinos escamosos y tejido de granulación. Al comprimir el trago presenta vértigo con nistagmo horizontal hacia la derecha. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta prioritaria?**

A Otitis media crónica simple; ciprofloxacino tópico y control

B Otitis media con efusión; observar 3 meses

C Colesteatoma con fístula laberíntica; TAC de peñasco sin contraste y derivación urgente a otorrinolaringología para cirugía

D Otitis externa maligna; ciprofloxacino oral

E Neuronitis vestibular; corticoides y reposo

Respuesta C. Perforación marginal en la pars flácida con escamas nacaradas y otorrea fétida es colesteatoma. El vértigo y nistagmo al comprimir el trago es el signo de la fístula: erosión del canal semicircular lateral. Se pide TAC de peñasco sin contraste y se deriva para mastoidectomía.

▶ VER CLASE **6.03.1.023** **Patología de glándulas salivales** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.19 · Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo

QUÉ HAY QUE SABER

- Parotiditis viral (paperas): tumefacción parotídea bilateral dolorosa, puede complicarse con orquitis, meningitis o pancreatitis; manejo sintomático.
- Parotiditis bacteriana (S. aureus): adulto mayor deshidratado o postoperado; pus por conducto de Stenon; hidratación, sialogogos y antibiótico antiestafilocócico.
- Sialolitiasis: más frecuente en submandibular; dolor y aumento de volumen prandial.
- Tumores: 80% parotídeos y la mayoría benignos (adenoma pleomorfo, Warthin); parálisis facial, dolor, fijación o crecimiento rápido sugieren malignidad.
- Diferencial: Sjögren (bilateral crónico, xeroftalmía) y VIH. Derivar a ORL/cabeza y cuello: ecografía, PAAF; no hacer biopsia incisional parotídea.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 71

Un paciente de 38 años con cuadro de 6 meses con aumento de volumen en región preauricular derecha. Al examen físico se constata nódulo en región preauricular de 4 cm de diámetro, de consistencia blanda, indoloro a la palpación y fija, sin afectación de la piel que lo recubre. **El diagnóstico más probable:**

A Adenopatía tuberculosa
B Adenoma pleomorfo
C Lipoma
D Quiste sebáceo
E Sarcoma

Respuesta B. La ubicación preauricular sugiere un tumor de la parótida, y el adenoma pleomorfo es el tumor benigno más frecuente de esa glándula. Además, el cuadro es indoloro, de crecimiento lento y sin compromiso de la piel.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 178

Un paciente de 50 años consulta por aumento de volumen en la región masetérica izquierda, de crecimiento lento y consistencia dura. Al examen físico se palpa un tumor de 2 cm de diámetro, ubicado sobre la rama mandibular izquierda, de consistencia aumentada. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Lipoma
B Rabdomiosarcoma
C Adenopatía preauricular
D Tumor de parótida
E Quiste sebáceo

Respuesta D. Un tumor ubicado en esa zona sugiere un tumor de parótida. Los tumores benignos son más frecuentes que los malignos, y la parálisis facial y las adenopatías tumorales sugieren malignidad.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 50 años consulta por dolor y aumento de volumen agudo recurrente en la región submandibular derecha, que aparece típicamente al comenzar a comer y cede gradualmente 2 horas después. La palpación bimanual del piso de la boca revela una zona indurada milimétrica dolorosa a lo largo del trayecto del conducto salival. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el conducto excretor involucrado?**

A Parotiditis viral urliana; conducto de Stenon
B Sialolitiasis submandibular; conducto de Wharton
C Adenoma pleomorfo submandibular; conducto de Rivinus
D Ranula sublingual simple; conducto de Bartolino
E Angina de Ludwig inicial; conducto tirogloso persistente

Respuesta B. El dolor y el aumento de volumen desencadenados por la comida, el cólico salival, son propios de la sialolitiasis. La mayoría de los cálculos se forman en la glándula submandibular y se impactan en el conducto de Wharton.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 82 años, hospitalizado hace 5 días tras una cirugía abdominal mayor, en ayuno prolongado y con mala higiene oral, presenta fiebre de 38,9 °C y dolor intenso con aumento de volumen eritematoso y caliente de la región preauricular derecha. Tiene trismus leve. Al exprimir la glándula hacia adelante sale pus franco por la mucosa yugal, frente al segundo molar superior. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Extracción transoral del cálculo con anestesia local
B Hidratación endovenosa y cloxacilina endovenosa
C Parotidectomía superficial con preservación del nervio facial
D Sialogogos con gotas de limón y calor local
E Enucleación simple de la masa

Respuesta B. Es una parotiditis bacteriana aguda supurada, por vía ascendente a través del conducto de Stenon, en un paciente deshidratado. Se trata con hospitalización, rehidratación endovenosa y antibiótico antiestafilocócico, como cloxacilina o cefazolina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 168

Un niño de 6 años es traído por su madre, dado que desde hace 2 horas comenzó con dolor y aumento de volumen en la zona paro`dea derecha. Al examen físico se palpa la glándula parótida derecha aumentada de tamaño, dolorosa a la compresión. Al interrogatorio, la madre refiere que desde los 4 años ha presentado cuatro episodios similares, que han respondido al tratamiento con analgésicos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Síndrome de Sjögren
B Paro2di2s viral recurrente
C Li2asis del conducto de Stensen
D Paro2di2s crónica
E Tumor paroadeo

Respuesta C. Es una sialolitiasis clásica. La obstrucción produce dolor y aumento de volumen súbitos. La desobstrucción puede ser intermitente. El tratamiento suele ser con analgésico y, si se ve el cálculo a la salida del conducto salival, es posible retirarlo.

▶ VER CLASE 6.03.1.024 Poliposis nasal

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.12 · Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal

QUÉ HAY QUE SABER

- Rinosinusitis crónica con pólipos: obstrucción nasal bilateral, hiposmia/anosmia y rinorrea; pólipos grisáceos, translúcidos, insensibles y móviles.
- Asocia asma y enfermedad respiratoria exacerbada por AINE (tríada de Samter: asma, pólipos, intolerancia a aspirina).
- Pólipo nasal en niño: descartar fibrosis quística (test del sudor). Pólipo unilateral en adulto: descartar papiloma invertido o tumor.
- Manejo inicial: corticoide intranasal y lavados salinos; curso corto de corticoide oral en casos severos.
- Derivar a ORL para nasofibroscopía, TAC de cavidades perinasales y eventual cirugía endoscópica.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 58

Un paciente, con antecedente de rinitis alérgica, presenta obstrucción nasal marcada, asociada varios episodios de sinusitis en el último tiempo. Respira por la boca, por la obstrucción nasal. En la rinoscopía anterior, se visualizan numerosos pólipos en la mucosa, de aspecto pálido y brillante, que obstruyen completamente las fosas nasales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar fluticasona tópica c/12 horas
B Iniciar prednisona oral 1 mg/Kg/día por 7 días
C Solicitar TAC de cavidades paranasales
D Realizar cirugía endoscópica nasal
E Solicitar niveles plasmáticos de inmunoglobulinas

Respuesta B. En una poliposis bilateral con obstrucción completa se parte con un ciclo breve de corticoide oral. El corticoide intranasal se asocia después; la cirugía queda para los casos refractarios.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 38 años con asma de difícil control y obstrucción nasal bilateral crónica con hiposmia consulta por una crisis de disnea y sibilancias a los 30 minutos de tomar ibuprofeno por una cefalea. En la rinoscopía anterior tiene masas bilaterales, translúcidas, blanco grisáceas e indoloras al tacto, que ocupan ambas fosas. **¿Cuál es el diagnóstico y la medida fundamental?**

A Cornetes hipertróficos; turbinoplastia inmediata
B Tríada de Samter; evitar aspirina y AINE y tratar la poliposis con corticoide intranasal
C Papiloma invertido; resección amplia urgente
D Hematoma septal; drenaje quirúrgico inmediato
E Alergia a ibuprofeno solamente; cambiar a otro AINE

Respuesta B. Poliposis bilateral, asma de difícil control y broncoespasmo por un AINE forman la tríada de Samter. Se evita la aspirina y todos los AINE y se trata la poliposis con corticoide intranasal en dosis altas, con ciclos breves de prednisona; si es refractaria, cirugía endoscópica funcional.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 118

Un paciente, con antecedente de rinitis alérgica, presenta marcada obstrucción nasal marcada, asociada varios episodios de sinusitis en el último tiempo. En la rinoscopía anterior, se visualizan numerosos pólipos en la mucosa, de aspecto pálido y brillante. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Iniciar fluticasona tópica
B Iniciar prednisona oral
C Solicitar TAC de cavidades paranasales
D Realizar cirugía endoscópica nasal
E Solicitar niveles plasmáticos de inmunoglobulinas

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Iniciar prednisona oral (opción B). La poliposis nasal se trata con corticoides orales.

▶ VER CLASE 6.03.1.025 Rinorrea crónica

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.9 · Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales

QUÉ HAY QUE SABER

- Rinorrea >12 semanas: rinitis alérgica, rinitis no alérgica (vasomotora, gustatoria, del adulto mayor), rinosinusitis crónica o medicamentosa.
- Rinorrea acuosa unilateral clara, que aumenta al inclinarse, post-trauma o cirugía: sospechar fístula de LCR (beta-2 transferrina); derivar.
- Unilateral purulenta fétida en niño: cuerpo extraño; en adulto: sinusitis odontogénica o tumor.
- Manejo inicial: lavados salinos, corticoide intranasal; bromuro de ipratropio intranasal en rinitis vasomotora con rinorrea acuosa predominante.
- Derivar a ORL si es unilateral, sanguinolenta, refractaria o con sospecha de fístula o tumor.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 79

Un paciente de 80 años consulta por rinorrea bilateral, de tres meses de evolución, muy molesta, asociada a congestión nasal, que es más intensa en las mañanas y aumenta con los cambios de temperatura. **El diagnóstico más probable es:**

A Cáncer nasal
B Pólipos nasales
C Sinusitis bacteriana crónica
D Rinitis vasomotora
E Rinitis alérgica

Respuesta D. Rinitis vasomotora: empeora en la mañana y con los cambios de temperatura, también con el estrés y los alimentos muy calientes o condimentados. El cáncer da obstrucción y rinorrea serosanguinolenta unilateral, y los pólipos son bilaterales con marcada obstrucción, en pacientes jóvenes.

▶ VER CLASE 6.03.1.026 Rinorreas agudas

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.10 · Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

QUÉ HAY QUE SABER

- Rinofaringitis viral (resfrío común) es la causa más frecuente: autolimitado 7-10 días; manejo sintomático, sin antibióticos.
- Sospechar rinosinusitis bacteriana si: síntomas >10 días sin mejoría, inicio severo (fiebre ≥39 °C y rinorrea purulenta ≥3 días) o doble empeoramiento.
- Tratamiento bacteriana: amoxicilina (niños 80-90 mg/kg/día; adultos 500 mg-1 g c/8-12 h) por 7-10 días; si falla, amoxicilina-clavulánico.
- Coadyuvantes: lavado nasal con suero fisiológico, corticoide intranasal; no se necesita radiografía para el diagnóstico.
- Banderas rojas: edema/eritema periorbitario, proptosis, diplopía, cefalea intensa o compromiso de conciencia: complicación orbitaria o intracraneal, derivar urgente.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 139

Un paciente de 17 años consulta por un cuadro que inició hace 12 días, consistente en congestión nasal, rinorrea mucosa abundante y odinofagia. En los últimos días la rinorrea se vuelve purulenta y empeoran los síntomas, agregándose sensación febril y tos seca mayor en las noches. Al examen físico se constata fiebre de 38,2 °C, FC 78 por minuto, FR 12 por minuto, faringe eritematosa con descarga posterior y rinorrea purulenta en ambas fosas nasales. Su examen cardiopulmonar es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Amoxicilina oral por 7 días
B Claritromicina oral por 10 días
C Aseo con suero fisiológico
D Corticoides orales por 7 días
E Antihistamínicos orales por 7 días

Respuesta A. Síntomas que superan los 10 días y además empeoran, con fiebre y rinorrea purulenta, definen una rinosinusitis aguda bacteriana. La primera línea es amoxicilina; los macrólidos quedan para alérgicos a penicilina. Los lavados nasales son coadyuvantes, no reemplazan al antibiótico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 143

Una mujer de 26 años, presenta un cuadro de 5 días de rinorrea, que a los dos días se vuelve mucopurulenta, agregándose odinofagia, y congestión nasal. Al examen físico se aprecia rinorrea, asociada a eritema y congestión faríngea. Se solicita una radiografía de senos paranasales que muestra velamiento de ambos senos maxilares. El tratamiento más adecuado es:

A Amoxicilina oral
B Amoxicilina más ácido clavulánico oral
C Corticoide tópico
D Descongestionantes tópicos
E Antihistamínicos orales

Respuesta A. Es una sinusitis aguda. Por el tiempo de evolución es probablemente viral y no requiere sino tratamiento sintomático. Sin embargo, no aparecía dentro de las alternativas y lo que se pregunta entonces es el tratamiento de la sinusitis bacteriana aguda, que de primera línea es con amoxicilina. Los descongestionantes tópicos, no son muy indicados, ya que tienen efectos adversos y no solucionan los demás síntomas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 66

Un niño de 5 años consulta por un cuadro de 7 días de evolución de rinorrea purulenta, descarga posterior, cefalea, fiebre y obstrucción nasal. En el último tiempo se agrega mayor fiebre, más edema y eritema periocular derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Queratoconjuntivitis viral
B Absceso periorbitario
C Conjuntivitis bacteriana
D Sinusitis maxilar
E Absceso frontal

Respuesta D. [Pregunta disputada] Es una mala pregunta. En estricto rigor parece una celulitis preorbitaria, que no estaba en las opciones, secundaria a una sinusitis (no queda claro si es maxilar, etmoidal o frontal). Tampoco parace un absceso orbitario (no existe el concepto periorbitario), por no tener limitación a la movilización de los movimientos, proptosis o otras alteraciones similares.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 118

Un niño de 5 años presenta un cuadro de 7 días de fiebre, cefalea, rinorrea purulenta abundante, descarga posterior y obstrucción nasal. Desde hace poco se agrega mayor fiebre, además de edema y eritema periocular derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Absceso frontal
B Conjuntivitis bacteriana
C Sinusitis maxilar
D Absceso periorbitario
E Conjuntivitis viral

Respuesta D. Diagnóstico: Absceso periorbitario (opción D).

▶ VER CLASE 6.03.1.027 Síndrome de apnea del sueño

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.15 · Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Adulto: ronquido, apneas presenciadas, somnolencia diurna (Epworth), cefalea matinal; factores: obesidad, cuello ancho, HTA refractaria, retrognatia.
- Niño: ronquido, apneas, respiración bucal, enuresis, déficit atencional y mal rendimiento; causa principal hipertrofia adenoamigdalina.
- Diagnóstico confirmatorio con polisomnografía (IAH ≥5 con síntomas o ≥15); poligrafía respiratoria domiciliaria en adultos de alta probabilidad.
- Complicaciones: HTA, arritmias, ACV, accidentes de tránsito; manejo inicial: baja de peso, evitar alcohol y sedantes, higiene del sueño.
- Derivar a ORL/broncopulmonar: CPAP en adultos moderado-severo; adenoamigdalectomía en niños con hipertrofia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 5 años tiene ronquidos nocturnos desde hace 6 meses y pausas respiratorias de hasta 15 segundos, con despertares sobresaltados y sudoración profusa. De día respira por la boca y tiene retraso pondoestatural. Sus amígdalas son grado 4 de Brodsky y se tocan en la línea media. **¿Cuál es la conducta más indicada?**

A Antibióticos orales profilácticos por 6 meses
B Adenoamigdalectomía bilateral
C Descongestionantes nasales tópicos nocturnos
D Observación hasta los 12 años
E Estimulantes del sistema nervioso central

Respuesta B. SAHOS infantil con repercusión en el crecimiento y amígdalas grado 4: es la indicación quirúrgica absoluta de adenoamigdalectomía. Esperar expone a cor pulmonale, falla de crecimiento y alteraciones craneofaciales.

▶ VER CLASE 6.03.1.028 Síndrome respirador bucal

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.15 · Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Niño que respira por la boca: causas principales hipertrofia adenoidea, hipertrofia amigdalina y rinitis alérgica.
- Facies adenoidea: boca abierta, cara alargada, paladar ojival, maloclusión, ojeras; asocia ronquido, apneas, voz hiponasal y OME recurrente.
- Estudio: radiografía lateral de cavum para evaluar tamaño adenoideo; buscar apneas del sueño.
- Manejo inicial: corticoide intranasal y tratamiento de la rinitis alérgica; lavados nasales.
- Seguimiento: si persiste obstrucción, apneas u otitis recurrente, adenoidectomía ± amigdalectomía; coordinar con ortodoncia y fonoaudiología.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 48

Un niño de 7 años, respirador bucal, es traído por su madre. No presenta apnea del sueño ni infecciones a repetición. Al examen físico no tiene obstrucción nasal y se observa faringe con amígdalas grado II. Se solicita radiografía de cavum, que constata hipertrofia adenoidea con 80% de obstrucción. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Desloratadina oral
B Fluticasona intranasal
C Adenoidectomía
D Observar evolución y controlar ambulatoriamente
E Solicitar TAC de cavidades paranasales

Respuesta D. Sin apnea, sin infecciones recurrentes y sin complicaciones, no hay indicación quirúrgica: se observa. La hipertrofia adenoidea involuciona con la edad. La cirugía se reserva para SAHOS u otras complicaciones.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 141

Un niño de 6 años consulta por epistaxis bilateral frecuent

E Además, tiene antecedente de ser respirador bucal, roncar en la noche y presentar infecciones respiratorias altas a repetición. El diagnóstico más probable es:
A Rinofibroangioma bilateral
B Rinitis alérgica
C Enfermedad de von Willebrand
D Hipertrofia de adenoides

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Además, tiene antecedente de ser respirador bucal, roncar en la noche y presentar infecciones respiratorias altas a repetición. El diagnóstico más probable es:). El respirador bucal es un motivo de consulta frecuente en pediatría y otorrinolaringología.

▶ VER CLASE **6.03.1.029** **Síndrome vertiginoso** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.7 · Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière

QUÉ HAY QUE SABER

- Diferenciar vértigo periférico (intenso, nistagmo horizontal-rotatorio unidireccional que se inhibe con la fijación, síntomas auditivos) de central.
- VPPB: segundos, desencadenado por cambios de posición, Dix-Hallpike positiva; Ménière: horas con hipoacusia fluctuante, tinnitus y plenitud; neuronitis: días, sin hipoacusia.
- Banderas rojas centrales: HINTS central, nistagmo vertical o cambiante, ataxia, diplopía, disartria, cefalea, factores de riesgo vascular.
- Manejo inicial: sedantes vestibulares por pocos días (dimenhidrinato, tietilperazina); maniobra de Epley en VPPB del canal posterior.
- Derivar a ORL para estudio vestibular y audiometría; sospecha central: imagen y neurología urgente.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 168

Un paciente de 35 años presenta un golpe en la cabeza, debido a una caída a nivel, hace un mes. Desde entonces ha presentado reiterados episodios de vértigo intenso, de segundos de duración, que aparece con algunos movimientos de la cabeza. No tiene síntomas auditivos y su examen neurológico muestra movilidad coordinada y conservada, sin alteraciones de la marcha ni del examen de pares craneanos. Los síntomas se reproducen con las maniobras de Dix-Hallpike. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Difenidol 25 mg al día por 7 días
B Betahistina 8 mg cada 12 horas por 1 mes
C Solicitar prueba calórica
D Solicitar resonancia magnética nuclear de troncoencéfalo y cerebro
E Realizar maniobras de reposición vestibular

Respuesta E. Vértigo de segundos gatillado por movimientos de la cabeza, sin síntomas auditivos ni focalidad, con Dix-Hallpike positivo: VPPB (el traumatismo de cráneo puede desprender otoconias). Se trata con maniobras de reposición (Epley); no se indican fármacos ni neuroimágenes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 154

Paciente de 50 años con episodios de vértigo rotatorio, tinnitus unilateral fluctuante e hipoacusia neurosensorial ipsilateral. Los síntomas duran horas. Audiometría disponible en una semana. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Enfermedad de Ménière
B Vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB)
C Neuritis vestibular
D ACV de fosa posterior
E Schwannoma vestibular

Respuesta A. Vértigo episódico de horas, con hipoacusia neurosensorial y tinnitus fluctuantes del mismo lado: enfermedad de Menière. El VPPB dura segundos y no tiene hipoacusia; la neuronitis dura días y no tiene síntomas auditivos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 137

Paciente con vértigo posicional y maniobra de Dix-Hallpike positiva para canal posterior izquierdo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Betahistina oral por 4 semanas

B Dimenhidrinato oral por 7 días

C Maniobras de reposición canalicular (Epley)

D Derivar a neurología urgente

E Prednisona oral 1 mg/kg/día

Respuesta C. Vértigo posicional con Dix-Hallpike positivo: VPPB del canal posterior. La conducta de primera línea es la maniobra de reposición canalicular de Epley.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 7

Un paciente presenta vértigo, de segundos de duración, que se le produce al girar la cabeza a derecha, mientras está acostado. No tiene síntomas auditivos y como antecedente refiere haber sufrido un traumatismo encefálico hace 10 días, en un accidente de trabajo. No presenta adiadococinesia ni dismetría. El resto de su examen físico es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar flunarizina

B Iniciar tietilperazina

C Solicitar un TAC de oídos

D Derivar para maniobras de reposición vestibular

E Iniciar difenidol

Respuesta D. Es un vértigo postural paroxístico benigno clásico, aquí postraumático: segundos de duración, gatillado por el giro de la cabeza y sin síntomas auditivos. Se trata con maniobras de reposición vestibular, no con fármacos.

▶ VER CLASE 6.03.1.030 Sinusopatías crónicas

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.10 · Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

QUÉ HAY QUE SABER

- Rinosinusitis crónica: ≥12 semanas con ≥2 síntomas (obstrucción, rinorrea anterior/posterior, dolor facial, hiposmia), uno obstrucción o rinorrea, más evidencia endoscópica o TAC.
- Se divide en con y sin pólipos; factores: rinitis alérgica, asma, alteraciones anatómicas, origen odontogénico (unilateral maxilar).
- Tratamiento inicial: lavados nasales salinos de alto volumen y corticoide intranasal por 8-12 semanas.
- Estudio: TAC de cavidades perinasales (no radiografía) cuando falla el tratamiento médico o se plantea cirugía.
- Derivar a ORL si es refractaria, unilateral, poliposa o con complicaciones: cirugía endoscópica funcional.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 69

Paciente de 43 años presenta obstrucción nasal marcada, asociada a rinorrea de 5 años de evolución, con sensación de presión facial, cefalea e hiposmia. La radiografía de cavidades paranasales muestra velamiento de ambos senos maxilares. La TAC de cavidades paranasales muestra secreciones e inflamación de la mucosa de ambos senos maxilares y de las celdillas etmoidales bilaterales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Fluticasona nasal

B Azitromicina

C Cirugía endoscópica nasal

D Rinomanometría

E Resonancia magnética nuclear de cavidades paranasales

Respuesta A. Síntomas nasosinusales de más de 12 semanas (obstrucción, rinorrea, presión facial, hiposmia) con compromiso mucoso en la TAC definen rinosinusitis crónica. El tratamiento de primera línea son los corticoides intranasales y los lavados nasales con solución salina. La cirugía endoscópica se reserva para la falla del tratamiento médico máximo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 117

Una paciente con un cuadro de 5 años de evolución de marcada obstrucción nasal y rinorrea acuosa. Se realiza una radiografía de cavidades paranasales, que muestra velamiento de los senos maxilares. Se solicita un TAC de cavidades paranasales que muestra engrosamiento de la mucosa de los senos etmoidales y maxilares. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Iniciar fluticasona tópica

B Realizar cirugía endoscópica nasal

C Solicitar rinomanometría

D Indicar tratamiento antibiótico

E Iniciar antihistamínicos orales

Respuesta A. Parecía una rinitis crónica, con predominio de síntomas obstructivos, por lo que de primera línea se deben indicar corticoides tópicos.

▶ VER CLASE 6.03.1.031 Tinitus

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.6 · Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

QUÉ HAY QUE SABER

- Tinnitus subjetivo es lo más frecuente; suele asociarse a hipoacusia sensorioneural (presbiacusia, trauma acústico, ototóxicos).
- Siempre evaluar con audiometría; tinnitus unilateral con hipoacusia asimétrica: descartar neurinoma del acústico con RM.
- Tinnitus pulsátil: sospechar causa vascular (paraganglioma, malformación, hipertensión intracraneana); requiere imagen.
- Otras causas: tapón de cerumen, Ménière (con vértigo e hipoacusia fluctuante), salicilatos, aminoglucósidos.
- Manejo inicial: tranquilizar, retirar ototóxicos, evitar ruido, manejar ansiedad/insomnio; derivar a ORL para estudio y audífonos si hay hipoacusia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 55 años con tinnitus en el oído izquierdo de 6 meses, asociado a hipoacusia progresiva del mismo lado y leve inestabilidad. La otoscopía es normal. La audiometría muestra hipoacusia sensorioneural izquierda con discriminación de palabras desproporcionadamente baja. **¿Cuál es el estudio más adecuado?**

A Ninguno; indicar enmascaradores de ruido

B TAC de oídos sin contraste

C Resonancia magnética de conductos auditivos internos y ángulo pontocerebeloso con gadolinio

D Ecografía Doppler carotídea

E Impedanciometría

Respuesta C. El tinnitus unilateral con hipoacusia sensorioneural asimétrica y mala discriminación es la forma de presentación típica del schwannoma vestibular (neurinoma del acústico). Debe estudiarse con resonancia magnética con gadolinio de conductos auditivos internos. El tinnitus pulsátil orienta a causas vasculares. El tinnitus bilateral con presbiacusia simétrica no requiere imágenes.

▶ VER CLASE 6.03.1.032 Trastorno de deglución

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 1.3 · Disfagia y Trastornos Motores del Esófago

QUÉ HAY QUE SABER

- Disfagia orofaríngea (dificultad para iniciar la deglución, tos o atoro, regurgitación nasal) vs esofágica (sensación de detención retroesternal).
- Orofaríngea: ACV, Parkinson, ELA, miastenia, divertículo de Zenker (halitosis, regurgitación de alimentos no digeridos).
- Esofágica: sólidos progresiva sugiere obstrucción mecánica (cáncer, estenosis péptica); sólidos y líquidos desde inicio, trastorno motor (acalasia).
- Banderas rojas: baja de peso, progresión, anemia, edad >45, odinofagia, hematemesis; neumonías aspirativas.
- Derivar: endoscopía digestiva alta en disfagia esofágica; nasofibroscopía, videofluoroscopía y evaluación fonoaudiológica en disfagia orofaríngea.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 75 años, 3 semanas después de un ACV isquémico, presenta tos y voz húmeda al beber líquidos, y tuvo una neumonía hace 1 semana. Está alerta y cooperador. **¿Cuál es la conducta más adecuada para evaluar la deglución?**

A Evaluación fonoaudiológica de la deglución y estudio instrumental (videofluoroscopía o evaluación endoscópica de la deglución)

B Endoscopía digestiva alta

C Manometría esofágica

D Radiografía de tórax de control solamente

E Indicar gastrostomía de inmediato

Respuesta A. La tos o voz húmeda con líquidos y la neumonía aspirativa tras un ACV indican disfagia orofaríngea con aspiración. Se evalúa con tamizaje y evaluación fonoaudiológica, y se confirma con videofluoroscopía o FEES, que definen consistencias seguras y maniobras compensatorias. La endoscopía digestiva y la manometría evalúan la disfagia esofágica.

▶ VER CLASE 6.03.1.033 Trastornos de habla y lenguaje

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.2 · Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Hitos: balbuceo 6 meses, primeras palabras 12 meses, frases de 2 palabras a los 24 meses; inteligible para extraños a los 4 años.
- Retraso del lenguaje: siempre descartar hipoacusia con audiometría o potenciales evocados, aunque el tamizaje neonatal haya sido normal.
- Diferencial: trastorno del espectro autista (alteración de la interacción social), discapacidad intelectual, trastorno específico del lenguaje, deprivación.
- Dislalias (sustitución de fonemas) son esperables hasta los 4-5 años; la disfluencia transitoria es frecuente en preescolares.
- Derivar a fonoaudiología y neurología/ORL infantil ante retraso significativo, regresión o sospecha de TEA; control en programa de salud infantil.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 2 años y medio en control sano. Su madre refiere que dice solo 8 palabras aisladas y no combina 2 palabras. Comprende órdenes simples, mira a los ojos, juega con otros niños e imita. El examen físico es normal y no tiene antecedentes perinatales relevantes. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Tranquilizar y controlar a los 4 años

B Electroencefalograma

C Resonancia magnética cerebral

D Evaluación auditiva (descartar hipoacusia) y derivación a fonoaudiología

E Iniciar metilfenidato

Respuesta D. A los 2 años se esperan al menos 50 palabras y frases de 2 palabras. Un retraso del lenguaje expresivo requiere primero descartar hipoacusia con evaluación auditiva objetiva (potenciales evocados o audiometría según edad), además de evaluar desarrollo global y signos de trastorno del espectro autista, y derivar a fonoaudiología para estimulación precoz.

Situaciones clínicas de urgencia

18 códigos

▶ VER CLASE 6.03.2.001 **Absceso mastoídeo de otitis media aguda y crónica** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.4 · Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Mastoiditis aguda: complicación de OMA, más frecuente en niños; dolor, eritema y edema retroauricular, pabellón desplazado hacia adelante y abajo, fiebre.
- Absceso subperióstico: fluctuación retroauricular; absceso de Bezold en cuello (esternocleidomastoideo) en adultos.
- Manejo inicial: hospitalizar, antibiótico endovenoso (ceftriaxona ± cloxacilina; cubrir Pseudomonas si OMC), analgesia.
- TAC de oídos con contraste para evaluar absceso y complicaciones intracraneales (trombosis del seno sigmoideo, absceso cerebral, meningitis).
- Derivar urgente a ORL para drenaje, miringotomía/colleras o mastoidectomía.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 2 años presenta fiebre de 39,3 °C, irritabilidad y tumefacción retroauricular izquierda dolorosa y eritematosa que desplaza el pabellón hacia adelante y borra el surco retroauricular. La otoscopía muestra el tímpano izquierdo abombado e hiperémico. **¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica inicial más adecuada?**

A Amoxicilina con ácido clavulánico oral por 14 días y control ambulatorio en 48 horas

B Ecografía de partes blandas y alta con antiinflamatorios

C Hospitalizar de inmediato, TAC de peñasco con contraste e iniciar ceftriaxona endovenosa

D Drenaje por punción ambulatoria y cefadroxilo oral

E Gotas óticas de ciprofloxacino y radiografía simple de cráneo

Respuesta C. Mastoiditis aguda: urgencia que exige hospitalización, TAC de peñasco con contraste y ceftriaxona endovenosa, con evaluación por otorrinolaringología. El manejo ambulatorio con antibióticos orales no corresponde.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 16 meses consulta por fiebre de hasta 39,5 °C, irritabilidad y llanto continuo de 48 horas. Hace 8 días completó 7 días de amoxicilina por una otitis media aguda, con mejoría transitoria. Está febril y decaído. En la región retroauricular derecha hay una masa eritematosa, caliente y fluctuante, con borramiento del surco retroauricular y desplazamiento anteroinferior del pabellón. La otoscopía derecha muestra el conducto estrechado por edema posterosuperior y el tímpano eritematoso y abombado. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Amoxicilina con ácido clavulánico oral por 14 días y control en 48 horas

B Gotas óticas de ciprofloxacino y control ambulatorio

C Hospitalizar, TAC de peñasco y cerebro con contraste, ceftriaxona endovenosa, y evaluación urgente por otorrinolaringología

D Cloxacilina oral y observación del ganglio retroauricular

E Solo analgesia y reevaluación al día siguiente

Respuesta C. Mastoiditis aguda con probable absceso subperióstico: oreja desplazada, surco borrado y fluctuación. Se hospitaliza, se pide TAC con contraste y se inicia ceftriaxona endovenosa. La fluctuación obliga a evaluación urgente por otorrinolaringología para drenaje quirúrgico.

▶ VER CLASE 6.03.2.002 **Absceso periamigdalino** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.14 · Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

QUÉ HAY QUE SABER

- Complicación de faringoamigdalitis en adolescente/adulto joven: odinofagia unilateral intensa, fiebre, trismus, voz de papa y sialorrea.
- Examen: abombamiento del pilar anterior y paladar blando unilateral con desviación de la úvula al lado contrario.
- Diferencial: flegmón periamigdalino (sin colección, solo antibiótico); si sospecha extensión profunda, TAC cervical con contraste.

- Tratamiento: punción-aspiración o incisión y drenaje, más antibiótico (penicilina sódica o clindamicina EV, luego amoxicilina-clavulánico o clindamicina oral) por 10-14 días, analgesia e hidratación.
- Recurrencia o amigdalitis recurrente asociada: amigdalectomía diferida (4-6 semanas); hospitalizar si hay compromiso de vía aérea o no tolera oral.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 48

Hombre de 20 años con odinofagia severa, fiebre 39°C, dificultad para abrir la boca (trismus) y desviación de la úvula hacia el lado contrario. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Angina de Ludwig
B Faringitis estreptocócica
C Absceso periamigdalino
D Mononucleosis infecciosa
E Epiglotitis

Respuesta C. Odinofagia severa, trismus y úvula desviada al lado contrario: absceso periamigdalino, un proceso unilateral de la faringe. La angina de Ludwig es bilateral, del piso de la boca, de origen dental, con lengua protruida.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 119

Un paciente está en el tercer día de tratamiento con azitromicina, por una amigdalitis con exudado. Consulta por aumento de la odinofagia, asociada a imposibilidad de comer por trismo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Absceso periamigdalino
B Angina de Ludwig
C Mononucleosis infecciosa
D Absceso parafaríngeo
E Absceso retrofaríngeo

Respuesta A. Amigdalitis con exudado que empeora pese al antibiótico y suma trismo: absceso periamigdalino, la complicación supurativa clásica de la amigdalitis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 170

Un paciente de 23 años consulta por odinofagia intensa, asociada a fiebre, que han empeorado y que y en el último tiempo se agrega dificultades para comer, por trismus. Al examen físico presenta eritema faríngeo, exudado amigdalino bilateral y abomba- miento del pilar diafragmático derecho. El diagnóstico más probable es:

A Absceso retrofaríngeo
B Angina de Ludwig
C Amigdalitis ulcero-necrótica
D Absceso periamigdalino
E Mononucleosis infecciosa

Respuesta D. Diagnóstico: Absceso periamigdalino (opción D). Es un absceso periamigdalino clásico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 148

Paciente con contractura de músculos masticatorios con úvula desplazada. rigidez de nuca esbozada, dolor cervical, gran exudado de amígdalas bilaterales:

A Absceso retrofaringeo
B Flegmon periamigdalina
C Absceso peritonsila
D Absceso retrotonsilar
E Ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Absceso peritonsila).

▶ VER CLASE 6.03.2.003 Absceso profundo de cuello

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.14 · Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

QUÉ HAY QUE SABER

- Infecciones de espacios profundos (parafaríngeo, submandibular): origen dental, amigdalino o ganglionar; mayor riesgo en diabéticos e inmunodeprimidos.
- Angina de Ludwig: celulitis submandibular bilateral de origen dental, lengua elevada, piso de boca indurado; riesgo inminente de obstrucción de vía aérea.
- Clínica: fiebre, odinofagia, trismus, tortícolis, aumento de volumen cervical, disnea o estridor.
- Manejo inicial: asegurar vía aérea, hospitalizar, antibiótico EV de amplio espectro (ampicilina-sulbactam o clindamicina ± ceftriaxona), TAC cervical con contraste.
- Derivar urgente a ORL/cirugía para drenaje; complicaciones: mediastinitis, trombosis yugular (Lemierre) y ruptura carotídea.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 55 años con mala higiene dental consulta por aumento de volumen cervical anterior y submandibular bilateral, de consistencia dura "en madera" y dolorosa. Tiene fiebre, dificultad respiratoria, incapacidad para tragar la saliva y elevación forzada de la lengua, empujada hacia el paladar y hacia atrás. **¿Cuál es la prioridad absoluta en el manejo inmediato de este paciente?**

A Extracción inmediata en box de las piezas dentarias cariadas bajo anestesia local

B Asegurar y proteger la vía aérea de forma precoz (intubación guiada o traqueostomía)

C Corticoides orales en altas dosis y reposo en domicilio

D Radiografía panorámica dental ambulatoria

E Punción evacuadora con trocar en el piso de la boca sin anestesia

Respuesta B. Es una angina de Ludwig. La induración leñosa del piso de boca eleva y empuja la lengua hacia atrás, con riesgo inminente de obstrucción. Lo primero es asegurar la vía aérea, antes de cualquier drenaje o examen.

▶ VER CLASE 6.03.2.004 Absceso retrofaríngeo

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.14 · Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

QUÉ HAY QUE SABER

- Más frecuente en niños <5 años por supuración de ganglios retrofaríngeos tras infección respiratoria alta.
- Clínica: fiebre, odinofagia, sialorrea, rechazo alimentario, rigidez o tortícolis (no flexiona/extiende el cuello), estridor; abombamiento de pared posterior faríngea.
- Radiografía lateral de cuello: ensanchamiento del espacio prevertebral; confirmar con TAC cervical con contraste.
- Manejo inicial: asegurar vía aérea, hospitalizar, antibiótico EV (ampicilina-sulbactam o clindamicina), hidratación.
- Derivar a ORL para drenaje si hay colección significativa; riesgo de mediastinitis y obstrucción de vía aérea.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 2 años presenta fiebre de 39,2 °C, irritabilidad, rechazo alimentario, sialorrea y una postura fija del cuello en extensión con tortícolis dolorosa y estridor inspiratorio leve. En la radiografía lateral de cuello se evidencia un marcado ensanchamiento del espacio de partes blandas prevertebrales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y la complicación más temida de no mediar tratamiento urgente?**

A Absceso retrofaríngeo; mediastinitis necrotizante descendente

B Croup viral laringotraqueal; estenosis subglótica adquirida

C Epiglotitis aguda; fístula traqueoesofágica espontánea

D Absceso periamigdalino bilateral; trombosis de arteria basilar

E Mononucleosis infecciosa severa; rotura esplénica retardada

Respuesta A. Lactante con tortícolis, estridor y ensanchamiento prevertebral: absceso retrofaríngeo. La complicación más grave es la mediastinitis necrotizante descendente a través del danger space. Requiere hospitalización, TAC con contraste y drenaje quirúrgico.

▶ VER CLASE 6.03.2.005 Atresia coanal congénita

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.15 · Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

QUÉ HAY QUE SABER

- Bilateral: urgencia neonatal; el recién nacido es respirador nasal obligado: cianosis que mejora con el llanto y empeora al alimentarse.
- Diagnóstico: imposibilidad de pasar sonda nasogástrica por ambas fosas (>3 cm); confirmar con nasofibroscopía y TAC.
- Manejo inicial: cánula orofaríngea (Guedel) o chupete de McGovern; intubación si es necesario.
- Asociación con síndrome CHARGE (coloboma, cardiopatía, atresia coanal, retraso, genitales, oído): buscar otras malformaciones.
- Unilateral: rinorrea unilateral persistente en niño mayor. Derivar a ORL para corrección quirúrgica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de término presenta episodios de cianosis y dificultad respiratoria que empeoran al alimentarse y mejoran con el llanto. Al intentar pasar una sonda nasogástrica por ambas fosas nasales, esta no progresa más allá de 3 cm. **¿Cuál es el diagnóstico y la medida inmediata?**

A Laringomalacia; posición prona

B Taquipnea transitoria; oxígeno

C Hernia diafragmática; intubación y sonda

D Fístula traqueoesofágica; régimen cero

E Atresia de coanas bilateral; asegurar vía aérea oral (cánula de Guedel o chupete de McGovern) y derivar para TAC y cirugía

Respuesta E. El recién nacido es respirador nasal obligado: la atresia de coanas bilateral da cianosis cíclica que mejora con el llanto (respira por la boca) y empeora al alimentarse. Se sospecha si la sonda no pasa por las fosas nasales. Se asegura una vía aérea oral, se confirma con TAC y se corrige quirúrgicamente. Se asocia a CHARGE.

▶ VER CLASE 6.03.2.006 Barotrauma ótico y trauma acústico agudo

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.6 · Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

QUÉ HAY QUE SABER

- Barotrauma: dolor ótico e hipoacusia tras vuelo o buceo con disfunción tubaria; tímpano retraído, hemotímpano o perforación.
- Trauma acústico agudo: exposición a ruido intenso (explosión, disparo); hipoacusia sensorioneural con escotoma en 4 kHz y tinnitus.
- Manejo inicial barotrauma: analgesia, descongestionantes, maniobra de Valsalva; evitar volar o bucear hasta resolución.
- Trauma acústico agudo: corticoides orales precoces (prednisona 1 mg/kg/día) y audiometría.
- Derivar a ORL: vértigo o hipoacusia sensorioneural sugieren fístula perilinfática (urgencia); perforación que no cierra.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 90

Una paciente de 33 años consulta por otalgia y sensación de oído tapado, mayor a derecha. Refiere que el día anterior estuvo nadando, sumergiéndose a 1,5 metros de profundidad. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Otitis media aguda

B Otitis media con efusión

C Perforación timpánica

D Otitis externa

E Barotrauma

Respuesta E. Otalgia y oído tapado justo después de un cambio brusco de presión, como el buceo, un vuelo o un cambio de altitud, es un barotrauma ótico. Se maneja con analgesia, descongestionantes y evitando nuevos cambios de presión hasta que se resuelva.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 72 años consulta porque desde hace 3 años presenta dificultad para entender las conversaciones cuando asiste a reuniones familiares o en lugares con ruido de fondo, refiriendo que "oye pero no entiende". No tiene otalgia ni vértigo. La audiometría demuestra una hipoacusia sensorioneural bilateral y simétrica, con mayor caída en los tonos agudos (3000 a 8000 Hz) y caída de la discriminación de la palabra al 60%. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el beneficio en el sistema de salud chileno?**

A Otoesclerosis bilateral; resolución quirúrgica con estapedectomía GES

B Presbiacusia; patología con Garantía Explícita en Salud (GES) con indicación de audífonos bilaterales

C Enfermedad de Ménière bilateral; tratamiento con restricción de sal y acetazolamida

D Trauma acústico crónico; derivación a mutualidad de seguridad laboral para indemnización

E Neurinoma del acústico bilateral; estudio genético urgente para Neurofibromatosis tipo 1

Respuesta B. Es presbiacusia: hipoacusia sensorioneural bilateral, simétrica, en agudos, con mala discriminación en ambientes ruidosos. En Chile, la hipoacusia en personas de 65 años y más tiene GES, con confirmación diagnóstica, audífonos y rehabilitación.

▶ VER CLASE 6.03.2.007 Cuerpo extraño en el oído

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.18 · Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

QUÉ HAY QUE SABER

- Más frecuente en niños; objetos inertes (semillas, piedras, juguetes) o insectos vivos; puede presentarse con otalgia, otorrea o hipoacusia.
- Pilas de botón: urgencia, extracción inmediata por necrosis tisular; no irrigar.
- Insecto vivo: inmovilizar primero con aceite mineral o lidocaína, luego extraer.
- No irrigar materiales orgánicos (semillas se hinchan) ni si hay perforación timpánica; no intentar extracción sin visión ni instrumental adecuado.
- Derivar a ORL si es esférico, impactado, hay perforación, falla un intento o el niño no coopera (puede requerir anestesia).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 5 años se introdujo un poroto en el oído derecho hace 1 día. Coopera con el examen. A la otoscopía se observa un cuerpo extraño redondo y liso que ocupa el conducto auditivo externo, sin visualizar el tímpano. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Extracción en seco con gancho romo o microaspiración bajo visión directa, derivando a otorrinolaringología si falla

B Lavado ótico con agua tibia

C Gotas de agua oxigenada para disolverlo

D Extracción con pinza cocodrilo

E Esperar su expulsión espontánea

Respuesta A. Semillas y legumbres absorben agua y se hinchan, así que el lavado está prohibido. Se extraen en seco, con gancho romo pasado por detrás del objeto o con microaspirador, bajo visión. La pinza resbala sobre un objeto redondo y lo empuja hacia el tímpano. Si el niño no coopera o falla el intento, se deriva para extracción bajo microscopio.

▶ VER CLASE 6.03.2.008 Cuerpo extraño en el esófago

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Gastroenterología 5.4 · Cuerpo Extraño Digestivo
Otorrino 14.18 · Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

QUÉ HAY QUE SABER

- Niños: monedas (en esófago se ven de frente en radiografía AP; en tráquea de perfil), pilas, imanes. Adultos: bolo alimentario (carne) sobre estenosis o anillo.
- Clínica: disfagia, odinofagia, sialorrea, incapacidad para tragar saliva, dolor retroesternal; puede ser asintomático.
- Radiografía de cuello y tórax AP y lateral; objetos no radiopacos pueden requerir TAC.
- Pila de botón esofágica, objeto punzante o impactación con sialorrea: endoscopía urgente (<2 horas en pilas). No inducir vómito.
- Derivar para extracción endoscópica; signos de perforación (enfisema subcutáneo, fiebre, dolor) obligan a cirugía urgente.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 2 años es traído a urgencia porque hace 1 hora se tragó una pila de botón del control remoto. Presenta sialorrea y rechaza los líquidos, sin dificultad respiratoria. La radiografía muestra una imagen redonda radiopaca con doble contorno en el tercio superior del esófago. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Esperar 24 horas a que pase al estómago y controlar con radiografía
B Dar una bebida carbonatada para empujarla al estómago
C Inducir el vómito
D Indicar laxantes y revisar las deposiciones
E Endoscopía digestiva alta de urgencia para extraer la pila de inmediato

Respuesta E. Una pila de botón en el esófago es una emergencia: la corriente eléctrica produce necrosis por licuefacción en unas 2 horas, con riesgo de perforación y de fístula traqueoesofágica o aortoesofágica. Se extrae por endoscopía urgente. El doble contorno la distingue de una moneda. Inducir el vómito está contraindicado.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 2 años llevado a urgencias porque hace 1 hora tragó una pila de botón del control remoto. Está asintomático. La radiografía de tórax muestra la pila en el esófago medio, con signo del "doble halo". **¿Cuál es la conducta?**

A Observar y repetir la radiografía en 24 horas
B Extracción endoscópica inmediata
C Observar con radiografía cada 1–2 semanas
D Administrar un laxante
E Endoscopía electiva solo si aparecen síntomas

Respuesta B. Pila de botón en el esófago: emergencia. La corriente genera una quemadura de la pared en horas, con riesgo de perforación, fístula traqueoesofágica y mediastinitis. Extracción endoscópica inmediata, aunque el niño esté asintomático.

▶ VER CLASE 6.03.2.009 Cuerpo extraño en vía aérea

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Otorrino 14.18 · Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

QUÉ HAY QUE SABER

- Más frecuente en niños de 1-3 años (maní, frutos secos); episodio de atoro presenciado con tos súbita, luego sibilancias unilaterales o hipoventilación.
- Obstrucción completa: maniobra de Heimlich (>1 año) o golpes en espalda y compresiones torácicas (lactante); no barrer a ciegas.
- Radiografía de tórax inspiración-espiración: atrapamiento aéreo unilateral; puede ser normal (objetos radiolúcidos).
- Neumonía recurrente o persistente en el mismo lóbulo: sospechar cuerpo extraño retenido.
- Derivar para broncoscopía rígida ante la sola sospecha clínica, incluso con radiografía normal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 3 años, mientras comía maní, presentó tos asfíctica súbita con cianosis que cedió en pocos minutos. Ahora tiene tos ocasional, está eupneico y saturando 96%. Al examen hay murmullo pulmonar disminuido y sibilancias localizadas en la base derecha. La radiografía en inspiración y espiración muestra atrapamiento aéreo en el pulmón derecho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Salbutamol inhalado y alta con control
B Broncoscopía rígida urgente en pabellón, bajo anestesia general
C Fibrobroncoscopía flexible ambulatoria en 2 semanas
D Kinesioterapia respiratoria con drenaje postural
E Amoxicilina oral y control en 7 días

Respuesta B. Un síndrome de penetración seguido de signos focales (hipoventilación y sibilancias unilaterales) y atrapamiento aéreo es aspiración de cuerpo extraño hasta demostrar lo contrario, incluso con radiografía normal. La conducta es la broncoscopía rígida urgente, diagnóstica y terapéutica. La kinesioterapia puede movilizar el cuerpo extraño y obstruir la vía aérea.

▶ VER CLASE 6.03.2.010 Cuerpo extraño nasal

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.18 · Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

QUÉ HAY QUE SABER

- Niño preescolar con rinorrea unilateral purulenta y fétida: cuerpo extraño nasal hasta demostrar lo contrario.
- Pila de botón o imanes: urgencia por necrosis y perforación septal en pocas horas; extracción inmediata.
- Manejo inicial: vasoconstrictor tópico, técnica de presión positiva ("beso de la madre") o soplar con la fosa contralateral ocluida.
- Extraer con pinza o gancho solo con buena visión y cooperación; evitar empujar hacia la rinofaringe (riesgo de aspiración).
- Derivar a ORL si falla el primer intento, el objeto es posterior, impactado o el niño no coopera.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una niña de 3 años es llevada a urgencia porque hace 2 horas se introdujo en la fosa nasal derecha un objeto metálico plano, sacado del control remoto del televisor. Tiene dolor nasal y escasa secreción sanguinolenta por esa narina. En la rinoscopía anterior se ve una superficie metálica circular brillante a 1,5 cm del vestíbulo, con mucosa septal edematosa, pálida y de tinte negruzco. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Lavado abundante de la fosa nasal con suero fisiológico para neutralizar el pH

B Extracción inmediata con gancho romo por detrás del objeto o derivación urgente a pabellón, sin irrigar

C Descongestionantes orales y control con otorrinolaringólogo en 48 horas

D Gotas de vaselina líquida para que la pila se deslice a la rinofaringe

E Compresión externa del dorso nasal para aplastar la pila

Respuesta B. Es una pila de botón en la fosa nasal, una emergencia quirúrgica por quemadura alcalina que puede perforar el tabique en menos de 2 horas. Se extrae de inmediato y está prohibido irrigar, porque el líquido acelera la electrólisis.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 4 años consulta por 3 semanas de mucosidad purulenta amarillenta que sale solo por la fosa nasal derecha, con olor fétido muy intenso. Fue tratado con amoxicilina oral por sospecha de rinosinusitis, sin mejoría. **¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable que debe descartarse en primer lugar?**

A Rinitis alérgica estacional unilateral

B Cuerpo extraño nasal desapercibido en la fosa nasal derecha

C Atresia de coanas bilateral congénita tardía

D Fibrosis quística con sobreinfección por Pseudomonas

E Desviación septal cartilaginosa sin componente inflamatorio

Respuesta B. La rinorrea purulenta, unilateral y fétida persistente en un niño pequeño es el cuadro clásico de un cuerpo extraño nasal retenido. Requiere rinoscopía anterior o nasofibroscopía para verlo y extraerlo.

▶ VER CLASE 6.03.2.011 Epistaxis masiva

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.11 · Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

QUÉ HAY QUE SABER

- Epistaxis masiva o posterior: más frecuente en adulto mayor hipertenso o anticoagulado; sangrado por ambas fosas y hacia faringe, arteria esfenopalatina.
- ABC primero: proteger vía aérea, dos vías venosas, hemograma, grupo y Rh, pruebas de coagulación; reposición de volumen.
- Taponamiento anterior; si sigue sangrando a la faringe, taponamiento posterior (sonda Foley o balón) más anterior; hospitalizar con antibiótico profiláctico.
- Controlar presión arterial y revertir anticoagulación según indicación; taponamiento posterior se retira a las 48-72 horas.
- Derivar a ORL para ligadura/cauterización endoscópica de esfenopalatina o embolización si falla el taponamiento.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 71 años, hipertenso con tratamiento irregular, llega a urgencia con sangrado nasal bilateral abundante de 1 hora. Está pálido y sudoroso, con PA 190/105 mmHg y FC 105 lpm. Tras compresión digital durante 15 minutos y taponamiento anterior bilateral con Merocel, sigue cayendo sangre roja abundante por la pared posterior de la orofaringe, con tos y arcadas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Nitrato de plata en ambos lados del tabique

B Cambiar el Merocel y dar de alta con control en 48 horas

C Taponamiento posterior con sonda Foley, tapón anterior, hospitalización y antibiótico profiláctico

D Pedir cabeza hacia atrás y observación en el box

E Solo antihipertensivos orales y observar en casa

Respuesta C. Es una epistaxis posterior, probablemente de la arteria esfenopalatina en un adulto mayor hipertenso. Falló el tapón anterior y hay sangre fresca en la orofaringe. Se coloca Foley con 8 a 10 mL de agua, más tapón anterior ipsilateral; se hospitaliza con monitorización, se piden hemograma y pruebas de coagulación, se controla la presión y se da amoxicilina con clavulánico.

▶ VER CLASE 6.03.2.012 Fractura nasal reciente

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.12 · Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal

QUÉ HAY QUE SABER

- Traumatismo nasal con epistaxis, dolor, edema, deformidad o crepitación; el diagnóstico es clínico, la radiografía es poco útil.
- Siempre descartar hematoma septal (abombamiento violáceo del tabique) y lesiones asociadas: fractura orbitaria, nasoetmoidal, fístula de LCR.
- Manejo inicial: control de epistaxis, hielo, analgesia, antibiótico si hay herida abierta.
- Reducción cerrada idealmente en los primeros 7-10 días (antes de consolidar) o inmediata si no hay edema importante.
- Derivar a ORL en 3-5 días para reevaluar deformidad una vez disminuido el edema.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 22 años recibió un puñetazo en la nariz hace 2 horas. Tuvo epistaxis que ya cedió. Al examen hay edema y dolor del dorso nasal, laterorrinia hacia la izquierda y crepitación ósea. En la rinoscopía anterior el tabique no está abombado, la mucosa es normal y no hay hematoma septal. Respira bien por ambas fosas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Radiografía de huesos propios para decidir la cirugía

B Reducción abierta urgente hoy en pabellón

C Esperar 3 meses y realizar rinoseptoplastia

D Drenaje del tabique nasal

E Frío local, analgesia y reevaluación por otorrinolaringología a los 5 a 7 días, para reducción cerrada si persiste la deformidad

Respuesta E. En la fractura nasal lo urgente es descartar un hematoma septal, ya hecho. Si no hay hematoma, se indica frío y analgesia, y se reevalúa cuando baja el edema, a los 5 a 7 días, para reducción cerrada antes de las 2 semanas. El diagnóstico es clínico; la radiografía solo tiene valor médico-legal.

▶ VER CLASE 6.03.2.013 Hematoma nasoseptal

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.12 · Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal

QUÉ HAY QUE SABER

- Colección de sangre bajo el pericondrio septal tras trauma nasal: obstrucción nasal bilateral y abombamiento violáceo y blando del tabique.
- Urgencia: riesgo de necrosis del cartílago en 24-72 horas, absceso septal y nariz en silla de montar.
- Tratamiento: drenaje urgente (incisión o punción), taponamiento anterior bilateral para evitar recolección y antibiótico antiestafilocócico.
- En niños con trauma nasal siempre examinar el tabique con rinoscopía.
- Derivar a ORL para drenaje y control; absceso septal puede dar trombosis del seno cavernoso.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 171

Un paciente de 34 años, sin antecedentes, sufre caída mientras subía una escalera, resultando con golpe en su rostro, al ingreso se en buenas condiciones generales, pero con epistaxis. Se realiza especuloscopía nasal donde se aprecia engrosamiento septal bilateral y epistaxis anterior. **La conducta más adecuada en este caso es:**

A Drenaje por punción

B Observar y controlar en 2 semanas

C Drenaje quirúrgico urgente

D Antibióticos endovenosos

E Taponamiento nasal bilateral

Respuesta C. El engrosamiento septal bilateral tras un golpe es un hematoma del tabique. Requiere drenaje quirúrgico urgente, seguido de taponamiento y antibiótico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 168

Un paciente de 28 años presenta un pelotazo en la cara, hace 5 días, con golpe en la nariz. Evoluciona con dolor, edema, obstrucción nasal y luego sensación febril. Al examen físico se observa aumento de volumen bilateral, en relación al tabique nasal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Drenaje por punción con aguja fina

B Drenaje quirúrgico con bisturí

C Taponamiento anterior

D Administrar analgésicos

E Reducción en pabellón

Respuesta B. Un hematoma septal que lleva días y ya produce fiebre se ha sobreinfectado: es un absceso septal. Se drena con bisturí; la punción con aguja no basta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 101

Un paciente de 18 años sufre un pelotazo en la cara hace 7 días, evolucionando con dolor, obstrucción nasal, rinorrea purulenta y fiebre. Está subfebril y se aprecia aumento de volumen bilateral, en relación al septo nasal. En sus exámenes destaca leucocitosis de 15.000 blancos por mm3. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar drenaje con punción
B Indicar antibióticos orales
C Poner tapón, con gasas empapadas en antibióticos tópicos
D Indicar corticoides y descongestionantes
E Realizar drenaje inmediato con bisturí

Respuesta E. Es un hematoma septal bilateral. Debe drenarse en pabellón, de manera urgente, para evitar la necrosis del cartílago septal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 118

Adolescente con antecedente de trauma nasal hace 5-7 días, que consulta por fiebre y obstrucción nasal bilateral:

A Hematoma septal
B Absceso septal (confirmado por un ORL, Guevara se equivocó (también se equivoca guevara no olvidar))
C Staphylococcus aureus
D Streptococcus pneumoniae
E Escherichia coli

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Absceso septal (confirmado por un ORL, Guevara se equivocó (también se equivoca guevara no olvidar))).

▶ VER CLASE 6.03.2.014 Otohematoma

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.3 · Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Colección de sangre entre pericondrio y cartílago del pabellón tras trauma (deportes de contacto); aumento de volumen fluctuante y violáceo.
- Riesgo: necrosis del cartílago y fibrosis ("oreja en coliflor") o pericondritis si no se drena.
- Tratamiento: drenaje precoz por punción o incisión en condiciones estériles, más vendaje compresivo para evitar recolección.
- Antibiótico profiláctico con cobertura de Pseudomonas y estafilococo (ciprofloxacino) y control en 24-48 horas.
- Derivar a ORL si es recurrente, extenso, de más de 7 días o con signos de pericondritis.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 22 años, practicante de lucha libre, consulta por aumento de volumen fluctuante, violáceo y doloroso en la cara anterior del pabellón auricular derecho, tras un golpe hace 24 horas. Borra los relieves del pabellón. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Drenaje del hematoma (punción o incisión) y vendaje compresivo, para evitar la deformidad en "oreja en coliflor"
B Hielo y control en 1 semana
C Antibiótico oral solamente
D Esperar reabsorción espontánea
E Cirugía reconstructiva electiva en 6 meses

Respuesta A. El otohematoma es la colección de sangre entre el pericondrio y el cartílago auricular tras un trauma. Como el cartílago se nutre del pericondrio, si no se drena precozmente se produce necrosis, infección (pericondritis) y fibrosis con deformidad permanente (oreja en coliflor). Se drena y se aplica compresión para evitar la recolección, con control y antibiótico según el caso.

▶ VER CLASE 6.03.2.015 Otorragia

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.12 · Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

QUÉ HAY QUE SABER

- Sangrado por el conducto auditivo; causas: trauma del conducto (cotonito), perforación timpánica, otitis externa, OMA perforada o fractura de base de cráneo.
- Post-TEC: fractura del temporal; buscar otolicuorrea, signo de Battle, parálisis facial, hipoacusia y vértigo.
- Manejo inicial: no lavar ni introducir gotas, oído seco; otoscopía cuidadosa, analgesia.
- En TEC: evaluación neuroquirúrgica y TAC de cerebro y peñasco.
- Derivar a ORL ante perforación, parálisis facial, hipoacusia sensorioneural, vértigo o salida de LCR.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 30 años sufre un TEC por caída de altura. Glasgow 14. Presenta otorragia derecha, equimosis retroauricular derecha (signo de Battle) e hipoacusia derecha. La otoscopía muestra sangre en el conducto auditivo externo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Lavado de oído para visualizar el tímpano

B Taponamiento compacto del conducto auditivo

C Gotas óticas de ciprofloxacino y alta

D No manipular ni lavar el oído; TAC de cerebro y de hueso temporal por sospecha de fractura de base de cráneo y evaluación de parálisis facial

E Aspirar el conducto en el servicio de urgencia

Respuesta D. La otorragia postraumática con signo de Battle sugiere fractura del hueso temporal (base de cráneo media), que puede asociarse a fístula de LCR, lesión del oído medio o interno y parálisis facial. No se debe lavar ni taponar el oído (riesgo de meningitis). Se estudia con TAC de cerebro y de peñasco, se evalúa el nervio facial y la audición.

▶ VER CLASE 6.03.2.016 Perforación timpánica traumática

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Otorrino 14.6 · Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

QUÉ HAY QUE SABER

- Causas: golpe con mano abierta, cotonitos, barotrauma, explosión; otalgia súbita, otorragia escasa e hipoacusia de conducción.
- Manejo: mantener oído seco, no lavar ni usar gotas ototóxicas; analgesia. Antibiótico oral solo si hay infección o contaminación.
- La mayoría cierra espontáneamente en 4-8 semanas; control otoscópico y audiometría.
- Banderas rojas: vértigo, nistagmo, hipoacusia sensorioneural o parálisis facial: lesión de oído interno o fístula perilinfática, derivación urgente.
- Derivar a ORL si no cierra en 3 meses (timpanoplastía) o hay complicaciones.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 138

Paciente usuaria habitual de cotonito (hisopo) consulta por otalgia e hipoacusia leve tras su uso. En la otoscopía se observa una perforación timpánica traumática. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Control en 1 mes (resolución espontánea)

B Tapón de algodón y antibiótico tópico ótico

C Miringoplastía inmediata

D TAC de hueso temporal

E Derivar a ORL urgente

Respuesta A. La mayoría de las perforaciones timpánicas traumáticas pequeñas cierran espontáneamente en semanas. Se indica mantener el oído seco (no mojar, no lavar, no usar gotas salvo infección), analgesia, y control otoscópico y audiométrico. Se deriva con urgencia si hay vértigo, hipoacusia sensorioneural, parálisis facial u otorrea; si no cierra en 2 a 3 meses, timpanoplastía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 44

Una mujer de 32 años, consulta por dolor intenso en el oído izquierdo, que inició después de haberse limpiado con un cotonito (hisopo). No tiene síntomas vestibulares, aunque refiere hipoacusia moderada en dicho oído. Se realiza otoscopía, que muestra presencia de una perforación timpática triangular, con sangre en el conducto auditivo externo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Lavado de oídos

B Ciprofloxacino tópico

C Derivar a timpanoplastía

D Control en un mes

E TAC de oídos

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Lavado de oídos (opción A).

▶ VER CLASE 6.03.2.017 Síndrome vertiginoso agudo

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.20 · Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS

Otorrino 14.7 · Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome vestibular agudo: vértigo continuo con náuseas, vómitos y nistagmo; la principal decisión es distinguir periférico (neuronitis) de central (ACV de fosa posterior).
- HINTS: impulso cefálico alterado, nistagmo unidireccional horizontal y skew negativo sugieren periférico; impulso normal, nistagmo cambiante o skew positivo sugieren central.
- Banderas rojas: déficit neurológico, cefalea súbita, ataxia severa (no puede caminar), factores de riesgo vascular, hipoacusia súbita: imagen y neurología urgente.
- Neuronitis vestibular: sedante vestibular (dimenhidrinato) por máximo 2-3 días, corticoide (prednisona 1 mg/kg/día) e hidratación; movilización precoz.

- Derivar a ORL para estudio vestibular y rehabilitación; VPPB se trata con maniobras de reposición.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 88

Una paciente de 43 años presenta vértigo de 5 días de evolución, intenso, asociado a vómitos, lo que limita sus actividades. No tiene síntomas auditivos. **El diagnóstico más probable es:**

A Parálisis cocleovestibular
B Vértigo postural
C Hídrops endolinfático
D Neuronitis vestibular
E Neurinoma del acústico

Respuesta D. Vértigo intenso y continuo de días, con vómitos y sin síntomas auditivos: neuronitis vestibular. La ausencia de síntomas auditivos descarta la parálisis cocleovestibular y el hídrops endolinfático (Menière); el vértigo postural dura segundos.

▶ VER CLASE 6.03.2.018 Sordera súbita

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.6 · Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipoacusia sensorioneural ≥30 dB en 3 frecuencias contiguas instalada en <72 horas, generalmente unilateral, con tinnitus o plenitud.
- Diferenciar de tapón de cerumen u OME con otoscopía y diapasones (Weber lateraliza al sano, Rinne positivo).
- Tratamiento urgente: prednisona 1 mg/kg/día (máx. 60 mg) por 7-14 días, iniciar idealmente en las primeras 72 horas.
- Solicitar audiometría urgente (24-48 horas) y RM para descartar neurinoma del acústico.
- Derivar a ORL de forma urgente; corticoide intratimpánico como rescate.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 123

Paciente de 45 años con pérdida súbita de audición unilateral de 48 horas de evolución, sin vértigo ni acúfenos. Audiometría: hipoacusia neurosensorial unilateral de 50 dB. **¿Cuál es el tratamiento?**

A Corticoides orales (prednisona 1 mg/kg/día x 10 días)
B Antibióticos orales
C Antivirales (aciclovir)
D Solo observar, resolución espontánea
E Cirugía descompresiva del nervio auditivo

Respuesta A. Hipoacusia súbita neurosensorial: el tratamiento estándar son corticoides orales en dosis alta, prednisona 1 mg/kg/día, iniciados dentro de las primeras 72 horas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 110

Un hombre de 33 años, sin antecedentes de importancia, despierta con hipoacusia del oído izquierdo, asociado a tinitus, sin otros síntomas. No ha presentado vértigo y su otoscopía no muestra alteraciones. Su examen neurológico no aporta nueva información. **¿Cuál es el examen inicial para evaluar a este paciente?**

A Impedanciometría
B TAC de oído
C TAC de cerebro
D Prueba calórica
E Audiometría

Respuesta E. Hipoacusia brusca con tinnitus y otoscopía normal: el examen inicial es la audiometría, que confirma la pérdida sensorioneural y orienta el tratamiento urgente.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un abogado de 48 años consulta porque hace 36 horas despertó sin oír por el oído izquierdo, con un pito agudo continuo y sensación de presión. Pensó que era cera y se puso gotas de glicerina, sin mejoría. No tiene fiebre ni mareos. La otoscopía es normal en ambos oídos. En el diapasón, el Weber lateraliza hacia el oído derecho y el Rinne es positivo en ambos oídos. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta prioritaria?**

A Tapón de cerumen; lavado de oído

B Disfunción tubaria; descongestionantes y control en 3 semanas

C Hipoacusia sensorioneural súbita; prednisona oral 1 mg/kg/día y audiometría urgente

D Otitis media con efusión; observar 3 meses

E Neurinoma del acústico; cirugía inmediata

Respuesta C. Pérdida brusca de menos de 72 horas con otoscopía normal, Weber al oído sano y Rinne positivo: hipoacusia sensorioneural súbita. Es una urgencia: se inicia prednisona 1 mg/kg/día de inmediato y se pide audiometría urgente. La resonancia con gadolinio se programa una vez iniciado el tratamiento. Atribuirla a cerumen o a la trompa hace perder la ventana terapéutica.

Conocimientos generales

7 códigos

▶ VER CLASE 6.03.3.001

Detección de hipoacusia y sordera en niños

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.21 · Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizaje auditivo neonatal universal con emisiones otoacústicas antes del alta; en riesgo (UCI >5 días, prematuros) usar PEAT automatizado.
- Estrategia 1-3-6: tamizaje antes del mes, diagnóstico confirmado antes de los 3 meses e intervención antes de los 6 meses.
- GES: hipoacusia bilateral del prematuro (<32 semanas o <1.500 g) e hipoacusia moderada o mayor en menores de 4 años con audífonos.
- Pesquisa en control sano: preguntar si reacciona al ruido, balbuceo, desarrollo del lenguaje; cualquier sospecha parental justifica estudio.
- Seguimiento audiológico en factores de riesgo de hipoacusia tardía (CMV, meningitis, ototóxicos) aunque el tamizaje haya sido normal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de término sano, con tamizaje auditivo universal con emisiones otoacústicas que resultó "refiere" en el oído derecho en 2 ocasiones antes del alta. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Repetir las emisiones a los 2 años

B Tranquilizar, porque la hipoacusia unilateral no tiene importancia

C Confirmar con potenciales evocados auditivos de tronco cerebral antes de los 3 meses, para iniciar intervención antes de los 6 meses

D Esperar a que el niño comience a hablar

E Solicitar TAC de oídos inmediatamente

Respuesta C. El tamizaje auditivo neonatal universal (GES hipoacusia del prematuro y programa nacional) busca la meta 1-3-6: tamizaje antes del mes, confirmación diagnóstica con potenciales evocados auditivos antes de los 3 meses e intervención (audífonos, implante) antes de los 6 meses, para preservar el desarrollo del lenguaje. Un tamizaje alterado nunca debe esperar.

▶ VER CLASE 6.03.3.002

Pesquisa de trastornos del lenguaje

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.2 · Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Pesquisa en control de salud infantil con tests de desarrollo psicomotor (EEDP hasta 2 años, TEPSI 2-5 años) y pauta de lenguaje.
- Alerta: no balbucea a los 9-12 meses, sin palabras a los 16-18 meses, sin frases de 2 palabras a los 24 meses, pérdida de lenguaje adquirido.
- Ante retraso: descartar hipoacusia (audiometría/PEAT) y trastorno del espectro autista (M-CHAT).
- Estimulación: lectura diaria, conversación, limitar pantallas en menores de 2 años; programa Chile Crece Contigo.
- Derivar a fonoaudiología y neurología infantil según hallazgos; intervención precoz mejora el pronóstico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En el control sano de los 18 meses se evalúa el lenguaje de un niño. Su madre dice que no dice ninguna palabra con significado, aunque balbucea. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Normal; a los 18 meses aún no se espera ninguna palabra

B Señal de alerta: a los 18 meses se esperan al menos varias palabras con significado; requiere evaluación auditiva, del desarrollo (incluida pesquisa de autismo) y derivación a fonoaudiología

C Normal si es varón

D Esperar hasta los 3 años para evaluar

E Indicar que la madre le hable en un solo idioma y controlar a los 4 años

Respuesta B. Son señales de alerta: no balbucear a los 12 meses, no decir palabras a los 16 a 18 meses, no combinar 2 palabras a los 24 meses o cualquier pérdida de lenguaje. Ante ellas se descarta hipoacusia, se pesquisa trastorno del espectro autista (M-CHAT) y se deriva a fonoaudiología. En Chile se pesquisa con EEDP y TEPSI.

▶ VER CLASE 6.03.3.003 Prevención de alergias nasosinusales

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.9 · Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales

QUÉ HAY QUE SABER

- Control ambiental: fundas antiácaros, lavado de ropa de cama a ≥60 °C, retirar alfombras y peluches, ventilar y reducir humedad.
- Evitar humo de tabaco y contaminación intradomiciliaria (estufas a leña); mascotas fuera del dormitorio si hay sensibilización.
- Polinosis: cerrar ventanas en temporada alta (primavera), lentes, ducha al llegar a casa; iniciar corticoide intranasal antes de la temporada.
- Lactancia materna exclusiva y no retrasar la introducción de alimentos se asocian a menor atopia.
- Inmunoterapia específica (por especialista) modifica la historia natural y reduce progresión a asma en pacientes seleccionados.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 10 años con rinitis alérgica persistente moderada, con pruebas cutáneas positivas solo para ácaros del polvo doméstico (Dermatophagoides). **¿Cuál de las siguientes medidas de control ambiental es más adecuada?**

A Mantener alfombras y peluches en el dormitorio

B Uso de antibióticos profilácticos en invierno

C Evitar el consumo de leche

D Mantener la casa cerrada y sin ventilar

E Usar fundas antiácaros en colchón y almohada, lavar ropa de cama semanalmente con agua caliente, reducir alfombras y peluches y mantener baja la humedad del dormitorio

Respuesta E. La prevención en rinitis alérgica se basa en identificar y evitar el alérgeno. Para ácaros se recomiendan fundas antiácaros, lavado de ropa de cama con agua caliente, retirar alfombras, cortinas gruesas y peluches del dormitorio, ventilar y reducir la humedad, además de evitar el humo de tabaco. Se combina con corticoide intranasal e inmunoterapia en casos seleccionados.

▶ VER CLASE 6.03.3.004 Prevención de cáncer laríngeo

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.20 · Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

QUÉ HAY QUE SABER

- Principal medida: cesación tabáquica; tabaco y alcohol tienen efecto sinérgico en el riesgo de cáncer laríngeo.
- Otros factores: exposición ocupacional (asbesto, níquel, hidrocarburos), reflujo laringofaríngeo, VPH.
- Detección precoz: toda disfonía de más de 3 semanas, sobre todo en fumador mayor de 40 años, requiere laringoscopía.
- Lesiones premalignas (leucoplasia, displasia de cuerda vocal) requieren biopsia y seguimiento por ORL.
- Consejería breve antitabaco en cada atención (modelo 5A) y apoyo farmacológico (vareniclina, bupropión, TRN).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 50 años, fumador de 30 paquetes-año y consumidor de alcohol diario, consulta en APS por un control preventivo. No tiene síntomas. **¿Cuál es la medida más efectiva para prevenir el cáncer de laringe en este paciente?**

A Nasofibrolaringoscopía anual de tamizaje

B Antiinflamatorios diarios

C Vitamina E diaria

D Cesación tabáquica y reducción del consumo de alcohol

E Reposo vocal

Respuesta D. El tabaco es el principal factor de riesgo de cáncer de laringe y el alcohol potencia su efecto en forma sinérgica. La prevención primaria es la cesación tabáquica y la reducción del alcohol. No existe tamizaje poblacional recomendado; la clave es la detección precoz de síntomas: toda disfonía de más de 3 semanas en un fumador debe evaluarse con laringoscopía.

▶ VER CLASE 6.03.3.005 Prevención de cuerpo extraño en niños

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.18 · Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

QUÉ HAY QUE SABER

- No dar frutos secos (maní, nueces), uvas enteras, salchichas en trozos redondos ni dulces duros a menores de 4-5 años.
- Supervisar la alimentación: niño sentado, sin correr, reír ni jugar con comida en la boca.
- Juguetes adecuados a la edad (sin piezas pequeñas); guardar pilas de botón, imanes y monedas fuera del alcance.
- Enseñar a los padres primeros auxilios: golpes en la espalda y compresiones torácicas en lactantes, Heimlich en mayores de 1 año.
- Consejería anticipatoria en control de niño sano desde los 6 meses.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En el control sano de los 12 meses, la madre pregunta qué alimentos y objetos debe evitar para prevenir la aspiración de cuerpos extraños. **¿Cuál es la recomendación más adecuada?**

A Ofrecer maní y frutos secos enteros desde el año para estimular la masticación

B Evitar frutos secos enteros, uvas y salchichas enteras, caramelos duros y juguetes con piezas pequeñas hasta al menos los 4 a 5 años, y supervisar siempre la alimentación sentado

C Permitir que coma mientras corre para que no se distraiga

D Los juguetes con pilas de botón son seguros si están cerrados con pegamento

E Solo los globos de látex son peligrosos

Respuesta B. La aspiración de cuerpo extraño es más frecuente entre 1 y 3 años. Se previene evitando frutos secos enteros, semillas, uvas y salchichas enteras (cortarlas en trozos pequeños longitudinalmente), dulces duros, globos y objetos pequeños; con pilas de botón en compartimentos asegurados con tornillo; y comiendo sentado y supervisado, sin correr ni reír con comida en la boca.

▶ VER CLASE 6.03.3.006 Prevención de otitis externa

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.3 · Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Evitar cotonitos y manipulación del conducto: eliminan cerumen protector y producen microtrauma.
- Secar bien los oídos tras nadar o ducharse; tapones en nadadores frecuentes; ladear la cabeza para drenar el agua.
- Gotas acidificantes o de alcohol boricado tras el baño en pacientes con otitis externa recurrente (si tímpano íntegro).
- Tratar dermatitis del conducto y controlar glicemia en diabéticos (riesgo de otitis externa maligna).
- Limpieza periódica de audífonos y tapones.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Nadador de 16 años con 3 episodios de otitis externa difusa en el último verano, tratados con gotas antibióticas. Consulta para prevenir nuevos episodios. **¿Cuál es la recomendación más adecuada?**

A Limpiar diariamente el conducto con cotonito después de nadar

B Secar el pabellón y la entrada del conducto tras nadar (inclinando la cabeza o con secador a baja temperatura), usar tapones y evitar introducir cotonitos u objetos

C Usar gotas antibióticas profilácticas diarias durante todo el verano

D Lavarse los oídos con agua a presión semanalmente

E Antibiótico oral profiláctico

Respuesta B. La otitis externa se favorece por la humedad, la pérdida del cerumen protector y el trauma del conducto (cotonitos, rascado). Se previene manteniendo el conducto seco tras el baño (inclinar la cabeza, secador tibio, gotas acidificantes o alcohol boricado si no hay perforación), usando tapones y evitando la manipulación. Los antibióticos profilácticos favorecen resistencia y otomicosis.

▶ VER CLASE 6.03.3.007

Prevención de trauma acústico y daño por exposición a ruidos

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.6 · Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

QUÉ HAY QUE SABER

- Ruido ocupacional >85 dB por 8 horas produce hipoacusia sensorioneural irreversible; muesca característica en 4 kHz.
- Protocolo PREXOR (MINSAL): vigilancia de trabajadores expuestos a ruido con audiometrías periódicas; enfermedad profesional cubierta por la Ley 16.744.
- Medidas: reducir el ruido en la fuente, limitar tiempo de exposición, protectores auditivos (tapones u orejeras) bien utilizados.
- Ruido recreacional: audífonos a <60% del volumen máximo por <60 minutos (regla 60/60); protección en conciertos y disparos.
- Tinnitus o sensación de oído tapado tras exposición es señal de alarma; ante trauma acústico agudo, audiometría y evaluación precoz.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 30 años ingresa a trabajar a una maestranza donde el ruido medido en su puesto es de 92 dB durante la jornada de 8 horas. Su audiometría de ingreso es normal y no tiene síntomas. **¿Cuál es la medida preventiva más adecuada?**

A Protectores auditivos durante toda la exposición y audiometrías periódicas de vigilancia

B Ninguna, hasta que aparezca hipoacusia

C Corticoides orales profilácticos en los períodos de más ruido

D Audífonos desde el ingreso

E Lavados óticos mensuales

Respuesta A. Sobre 85 dB por 8 horas hay riesgo de hipoacusia laboral, cuyo daño no revierte. Se previene reduciendo el ruido en la fuente, usando protectores auditivos durante toda la exposición y vigilando con audiometrías periódicas (protocolo PREXOR del MINSAL), buscando precozmente la muesca en 4000 Hz.

Exámenes e imagenología

11 códigos

▶ VER CLASE 6.03.4.001

Radiografía de cavidades perinasales

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.10 · Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

QUÉ HAY QUE SABER

- Proyecciones: Waters (occipitomentoniana) para senos maxilares, Caldwell para frontales y etmoides; lateral para esfenoides.
- Signos de sinusitis: nivel hidroaéreo, opacificación completa o engrosamiento mucoso >4-5 mm; pero tiene baja sensibilidad y especificidad.
- No se requiere para el diagnóstico de rinosinusitis aguda, que es clínico; en niños pequeños los senos no están completamente desarrollados.
- Los senos frontales aparecen radiológicamente hacia los 6-8 años; maxilares y etmoidales están presentes desde el nacimiento.
- Ha sido reemplazada por la TAC cuando se sospecha complicación, enfermedad crónica o se planifica cirugía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 30 años con rinorrea purulenta, congestión nasal y dolor facial maxilar de 4 días, tras un resfrío. Afebril, en buen estado general, sin signos orbitarios ni neurológicos. Solicita una radiografía de cavidades perinasales. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a las imágenes?**

A No solicitar imágenes; el diagnóstico de rinosinusitis aguda es clínico, y las imágenes se reservan para complicaciones, falla de tratamiento o enfermedad crónica

B Radiografía de cavidades perinasales para confirmar sinusitis

C TAC de cavidades perinasales urgente

D Resonancia magnética

E Radiografía de cavum

Respuesta A. La rinosinusitis aguda es un diagnóstico clínico. La radiografía de cavidades perinasales tiene baja sensibilidad y especificidad (el velamiento también ocurre en resfríos virales) y no cambia el manejo. Si se requiere imagen (complicación orbitaria o intracraneana, cronicidad, planificación quirúrgica), el examen de elección es la TAC.

▶ VER CLASE 6.03.4.002 Radiografía de cavum

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.15 · Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Radiografía lateral de cavum (rinofaringe) para evaluar el tamaño de las adenoides en niños con respiración bucal, ronquido u OME.
- Relación adenoides/nasofaringe (índice de Fujioka): >0,7-0,8 sugiere hipertrofia obstructiva.
- Útil para indicar adenoidectomía junto con la clínica; la nasofibroscopía es el estándar para evaluar la vía aérea.
- En adultos, una masa en cavum obliga a descartar carcinoma nasofaríngeo (efusión unilateral persistente).
- La radiografía lateral de cuello también ayuda en absceso retrofaríngeo (ensanchamiento prevertebral).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 23

Un niño de 5 años presenta infecciones respiratorias a repetición, rinorrea bilateral frecuente y obstrucción nasal con respiración bucal habitual. La madre relata roncopatía y dificultades para dormir. Ha tenido dos episodios recientes de otitis media aguda que respondieron a amoxicilina. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?**

A Radiografía de cavum

B TAC de cavidades paranasales

C Nasofibroscopía

D Polisomnografía

E Niveles plasmáticos de IgE específica contra alérgenos respiratorios

Respuesta A. La sospecha es hipertrofia de adenoides. Aunque la nasofibroscopía es el mejor examen y se hará en segunda línea, el inicial es la radiografía de cavum, que es barata y menos molesta para el niño.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 23

Niño de 5 años presenta infecciones respiratorias a repetición, asociadas a rinorrea bilateral frecuente y obstrucción nasal con respiración bucal habitual. La madre relata roncopatía y dificultades para dormir. Recientemente ha presentado 2 episodios de otitis media aguda que respondieron a amoxicilina. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?**

A Radiografía de cavum

B TAC de cavidades paranasales

C Nasofibroscopía

D Polisomnografía

E Niveles plasmáticos de IgE específica contra alérgenos respiratorios

Respuesta A. Respiración bucal, ronquido, rinorrea y otitis recurrentes en un preescolar sugieren hipertrofia adenoidea. La radiografía lateral de cavum es un examen simple y accesible para iniciar el estudio, al mostrar la relación adenoides-nasofaringe. La nasofibroscopía la confirma en el nivel especializado y la polisomnografía se reserva para dudas sobre la gravedad del SAHOS.

▶ VER CLASE 6.03.4.003 TAC de cavidades perinasales

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.10 · Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen de elección para estudiar cavidades perinasales: rinosinusitis crónica, poliposis y planificación de cirugía endoscópica.
- Indicada en rinosinusitis aguda con sospecha de complicación orbitaria o intracraneal (con contraste) y en fracaso de tratamiento médico.
- Evaluar ocupación sinusal, permeabilidad del complejo osteomeatal, erosión ósea (tumor) y variantes anatómicas.
- Erosión ósea o masa unilateral sugiere tumor; complementar con RM.
- No se solicita en rinosinusitis aguda no complicada.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 7 años con rinosinusitis aguda de 5 días que presenta edema palpebral izquierdo, proptosis, dolor a la movilización ocular y disminución de la agudeza visual. Temperatura 39 °C. **¿Cuál es el examen de imagen de elección?**

A Radiografía de cavidades perinasales

B Ecografía ocular

C TAC de cavidades perinasales y órbitas con contraste

D Radiografía de cavum

E No requiere imágenes

Respuesta C. Proptosis, oftalmoplejía dolorosa y disminución visual en un niño con sinusitis indican celulitis orbitaria o absceso subperióstico, complicaciones de la etmoiditis. Requiere TAC de cavidades perinasales y órbitas con contraste urgente para identificar abscesos que necesitan drenaje, antibióticos endovenosos y evaluación por ORL y oftalmología. La TAC es también el examen para sinusitis crónica y planificación quirúrgica.

▶ VER CLASE 6.03.4.004 TAC cervical con contraste

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.14 · Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen de elección en infecciones profundas de cuello: diferencia celulitis/flegmón de absceso (colección hipodensa con realce periférico).
- Indicada en sospecha de absceso retrofaríngeo, parafaríngeo, angina de Ludwig o absceso periamigdalino con extensión.
- Evalúa extensión a mediastino, compromiso vascular (trombosis yugular) y de vía aérea.
- En masa cervical del adulto: caracteriza tamaño, necrosis ganglionar y tumor primario para etapificación.
- Precauciones: función renal y alergia al contraste; no retrasar el manejo de la vía aérea por el examen.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 35 años con odontalgia molar inferior hace 1 semana, ahora con fiebre de 39 °C, trismus, aumento de volumen submandibular y cervical lateral izquierdo doloroso y odinofagia. Sin estridor ni dificultad respiratoria. **¿Cuál es el examen de elección para evaluar este cuadro?**

A Radiografía de cuello lateral

B Ecografía Doppler carotídea

C TAC de cuello con contraste endovenoso

D Resonancia magnética sin contraste

E Panorámica dental exclusivamente

Respuesta C. La sospecha de infección profunda del cuello (absceso parafaríngeo, submandibular, angina de Ludwig) requiere TAC cervical con contraste: distingue celulitis de absceso, muestra su extensión (mediastino) y su relación con la vía aérea y los vasos. Se acompaña de antibióticos endovenosos y drenaje si hay colección. Antes, siempre asegurar la vía aérea.

▶ VER CLASE 6.03.4.005 TAC de oídos sin medio de contraste

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.2 · Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen de elección para estudiar hueso temporal: otitis media crónica, colesteatoma, malformaciones y fracturas del peñasco.
- Colesteatoma: masa de partes blandas con erosión ósea (escudo, huesecillos, conducto semicircular lateral, tegmen).
- En fractura de temporal post-TEC evalúa trazo longitudinal (hipoacusia conductiva) vs transverso (sensorioneural y parálisis facial).
- Para complicaciones intracraneales o absceso se requiere contraste o RM.
- Para sospecha de neurinoma del acústico el examen indicado es RM con gadolinio, no TAC.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 40 años con otorrea fétida crónica del oído derecho e hipoacusia progresiva. La otoscopía muestra una perforación timpánica marginal posterosuperior con material blanquecino descamativo. Se planifica cirugía. **¿Cuál es el examen de imagen de elección para evaluar la extensión de la lesión?**

A Audiometría solamente

B Radiografía de Schüller

C Resonancia magnética de cerebro con contraste como primer examen

D Ecografía de mastoides

E TAC de oídos (hueso temporal) sin medio de contraste

Respuesta E. Una perforación marginal o atical con escamas blanquecinas y otorrea fétida es un colesteatoma. La TAC de hueso temporal sin contraste, de alta resolución, es el examen de elección para evaluar la erosión ósea (cadena osicular, canal semicircular lateral, tegmen, canal del facial) y planificar la cirugía. La resonancia se usa ante sospecha de complicación intracraneana o recidiva.

▶ VER CLASE 6.03.4.006 Audiometría básica

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.5 · Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)

QUÉ HAY QUE SABER

- Mide umbrales auditivos por vía aérea y ósea en 250-8.000 Hz; normal ≤20-25 dB.
- Conductiva: vía ósea normal, vía aérea descendida (gap aéreo-óseo). Sensorioneural: ambas descendidas sin gap. Mixta: ambas descendidas con gap.
- Patrones: presbiacusia (caída bilateral en agudos), trauma acústico (muesca en 4 kHz), Ménière (caída en graves fluctuante).
- Grados: leve 26-40, moderada 41-60, severa 61-80 y profunda >80 dB.
- Hipoacusia asimétrica sensorioneural requiere RM; requiere cooperación (no útil en lactantes, usar PEAT/emisiones).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 136

Paciente con hipoacusia y tinnitus, examen otoneurológico normal. **¿Cuál es el examen a solicitar?**

A Potenciales evocados auditivos del tronco cerebral

B Impedanciometría

C RNM de ángulo pontocerebeloso

D TAC de peñascos

E Audiometría

Respuesta E. Ante hipoacusia con tinnitus, el primer examen es la audiometría: cuantifica la pérdida y dice si es de conducción o sensorioneural. La imagen y los potenciales evocados vienen después, según el resultado.

▶ VER CLASE 6.03.4.007 Emisiones otoacústicas

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.21 · Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen objetivo, rápido e inocuo que evalúa función de células ciliadas externas; base del tamizaje auditivo neonatal.
- Presentes (pasa): cóclea funcional; ausentes (refiere): repetir y si persiste, PEAT para confirmar.
- Puede fallar por vérnix, OME o detritus en el conducto (falso positivo).
- No evalúa la vía retrococlear: neuropatía auditiva (hiperbilirrubinemia, UCI) puede tener emisiones normales; en ellos usar PEAT.
- Normal descarta hipoacusia mayor a 30-40 dB de origen coclear.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Respecto al uso de emisiones otoacústicas en el tamizaje auditivo neonatal, se discute en una reunión clínica de neonatología. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

A Evalúan toda la vía auditiva hasta la corteza

B Un resultado normal descarta toda hipoacusia, incluida la retrococlear

C Requieren sedación profunda

D Evalúan la función de las células ciliadas externas de la cóclea; son rápidas e indoloras, pero no detectan la neuropatía auditiva, por lo que en recién nacidos de UCI se prefieren los potenciales evocados

E No se ven afectadas por líquido en el oído medio

Respuesta D. Las emisiones otoacústicas registran sonidos generados por las células ciliadas externas de la cóclea. Son un tamizaje rápido, no invasivo y sin sedación, pero se alteran con vérnix o líquido en el oído medio y no evalúan la vía retrococlear (neuropatía auditiva). En recién nacidos de UCI se usan potenciales evocados automatizados.

▶ VER CLASE 6.03.4.008 Impedanciometría básica

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.5 · Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)

QUÉ HAY QUE SABER

- Timpanometría: mide la compliance del sistema tímpano-osicular según presión del conducto.
- Curva A: normal; As: rigidez (otoesclerosis); Ad: hipermovilidad (disrupción de cadena); B: plana (efusión o perforación); C: presión negativa (disfunción tubaria).
- Curva B con volumen normal: OME; curva B con volumen aumentado: perforación o colleras permeables.
- Reflejo estapedial: ausente en patología conductiva, otoesclerosis o lesión del VII par.
- Útil en niños para confirmar otitis media con efusión y su seguimiento.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

¿Cuál de las siguientes curvas de la clasificación de Jerger en la timpanometría se asocia de forma característica a la presencia de líquido seroso intratimpánico en la otitis media con efusión? **¿Qué curva corresponde?**

A Curva A (pico centrado a 0 daPa con amplitud normal)

B Curva As (amplitud disminuida con presión normal)

C Curva B (curva aplanada sin punto de máxima compliance)

D Curva C (pico desplazado a presiones negativas menores a -100 daPa)

E Curva Ad (amplitud muy aumentada por discontinuidad de cadena)

Respuesta C. La curva B es plana, sin pico, porque el líquido del oído medio impide que el tímpano se mueva. La A es normal, la As indica rigidez como en la otoesclerosis, la C indica presión negativa por disfunción tubárica y la Ad indica disyunción de la cadena.

▶ VER CLASE 6.03.4.009 Polisomnografía

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.3 · Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)

QUÉ HAY QUE SABER

- Estándar diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño: registra EEG, oximetría, flujo, esfuerzo respiratorio, ECG y posición.
- Índice apnea-hipopnea (IAH): leve 5-15, moderado 15-30 y severo >30 eventos/hora en adultos; en niños ≥1 es anormal.
- Diferencia apnea obstructiva (esfuerzo presente) de central (sin esfuerzo).
- Poligrafía domiciliaria es alternativa en adultos con alta probabilidad sin comorbilidad mayor.
- Guía tratamiento: CPAP en moderado-severo; en niños con hipertrofia adenoamigdalina, cirugía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 52 años, IMC 36 kg/m2, hipertenso con 3 fármacos, con ronquido intenso, pausas respiratorias presenciadas por su pareja y somnolencia diurna (Epworth 15). Sin enfermedad cardiopulmonar ni neuromuscular significativa. **¿Cuál es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico?**

A Polisomnografía (o poligrafía respiratoria domiciliaria en alta probabilidad), que permite calcular el índice de apnea-hipopnea

B Espirometría

C Gases arteriales en vigilia

D Ecocardiograma

E TAC de cuello

Respuesta A. La polisomnografía nocturna es el estándar para el diagnóstico de SAHOS: registra EEG, flujo, esfuerzo, saturación y otras variables, y permite calcular el índice de apnea-hipopnea (IAH: 5 a 14 leve, 15 a 29 moderado, 30 o más grave). En pacientes con alta probabilidad clínica y sin comorbilidad relevante, la poligrafía domiciliaria es una alternativa válida.

▶ VER CLASE 6.03.4.010 Pruebas cutáneas de alergia

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.9 · Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales

QUÉ HAY QUE SABER

- Prick test: identifica sensibilización IgE mediada a alérgenos inhalantes (ácaros, pólenes, epitelios, hongos) o alimentarios.
- Positivo: pápula ≥3 mm mayor que el control negativo; requiere control positivo (histamina) y negativo (suero).
- Suspender antihistamínicos 5-7 días antes; los corticoides tópicos nasales no interfieren.
- Positividad indica sensibilización, no necesariamente alergia: debe correlacionarse con la clínica.
- Indicaciones: rinitis persistente moderada-severa, mal control, para dirigir control ambiental o inmunoterapia. Alternativa: IgE específica sérica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 25 años con rinitis persistente con estornudos, prurito nasal y rinorrea acuosa. Se solicitan pruebas cutáneas de alergia (prick test) para identificar alérgenos. **¿Cuál de los siguientes fármacos debe suspenderse días antes del examen porque produce falsos negativos?**

A Corticoide intranasal

B Antihistamínicos orales (por ejemplo, loratadina o cetirizina)

C Paracetamol

D Lavados nasales con suero fisiológico

E Anticonceptivos orales

Respuesta B. El prick test detecta sensibilización mediada por IgE con alta sensibilidad; se usa control positivo (histamina) y negativo. Los antihistamínicos H1 suprimen la roncha y deben suspenderse alrededor de 5 a 7 días antes, al igual que algunos antidepresivos tricíclicos. Los corticoides intranasales no interfieren. Un resultado positivo debe correlacionarse con la clínica.

▶ VER CLASE 6.03.4.011 **Estudio de VIII par** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.6 · Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

QUÉ HAY QUE SABER

- Evalúa porción coclear (audiometría, logoaudiometría, PEAT) y vestibular (pruebas calóricas, videonistagmografía, VHIT).
- Lesión retrococlear (neurinoma): hipoacusia asimétrica, mala discriminación verbal desproporcionada y PEAT con latencias prolongadas.
- RM con gadolinio es el examen definitivo para neurinoma del acústico.
- Pruebas calóricas: hipofunción unilateral en neuronitis vestibular, Ménière o neurinoma.
- El médico general debe interpretar el informe y derivar ante hipoacusia sensorioneural asimétrica, vértigo crónico o tinnitus unilateral.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 45 años con hipoacusia súbita del oído izquierdo de 2 días, con tinnitus y sensación de oído tapado. Otoscopía normal. Weber lateraliza a la derecha y Rinne positivo bilateral. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Lavado de oídos

B Antibiótico oral

C Audiometría urgente, corticoides sistémicos precoces y resonancia magnética de conductos auditivos internos con gadolinio para descartar patología retrococlear

D Observación por 1 mes

E Descongestionante nasal

Respuesta C. Weber hacia el oído sano con Rinne positivo indica hipoacusia sensorioneural del oído afectado. La hipoacusia sensorioneural súbita es una urgencia: se confirma con audiometría, se inician corticoides sistémicos precozmente y se estudia el VIII par con resonancia con gadolinio por la posibilidad de schwannoma vestibular. El estudio puede complementarse con potenciales evocados auditivos.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

14 códigos

▶ VER CLASE 6.03.5.001 **Drenaje de absceso mastoídeo** NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.4 · Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado en mastoiditis con absceso subperióstico o falla del tratamiento antibiótico EV a las 48 horas; lo realiza ORL.
- El médico general debe reconocer: eritema y fluctuación retroauricular, pabellón desplazado, fiebre en contexto de OMA.
- Previo a derivar: hospitalizar, antibiótico EV (ceftriaxona), analgesia y TAC de oídos con contraste.
- Procedimientos: miringotomía con colleras, punción/drenaje del absceso o mastoidectomía cortical.
- Derivar de forma urgente si hay signos de complicación intracraneal (cefalea, meningismo, compromiso de conciencia).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 3 años, con otitis media aguda izquierda hace 10 días, presenta fiebre de 39 °C, tumefacción retroauricular fluctuante y pabellón auricular desplazado hacia adelante. Lleva 24 horas con ceftriaxona endovenosa. El TAC de peñasco con contraste muestra ocupación de las celdillas mastoídeas y un absceso subperióstico de 2 cm, sin complicaciones intracraneales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Cambiar a amoxicilina con ácido clavulánico oral y dar de alta

B Mastoidectomía radical con vaciamiento del oído medio

C Mastoidectomía simple con drenaje del absceso, miringotomía y mantener el antibiótico endovenoso

D Solo gotas óticas de ciprofloxacino

E Observar 7 días más con el mismo antibiótico, sin procedimientos

Respuesta C. Un absceso subperióstico documentado es indicación de cirugía: mastoidectomía simple, cortical, con drenaje de la colección, junto con miringotomía para descomprimir el oído medio y cultivar, manteniendo el antibiótico endovenoso. La mastoidectomía radical es para el colesteatoma, no para la mastoiditis aguda.

▶ VER CLASE 6.03.5.002 Drenaje de absceso periamigdaliano

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.14 · Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

QUÉ HAY QUE SABER

- Técnicas: punción-aspiración con aguja (diagnóstica y terapéutica) o incisión y drenaje en el polo superior del pilar anterior.
- Se realiza con paciente sentado y anestesia local, evitando ir lateral o profundo por riesgo de lesión de la carótida interna.
- Previo a derivar: confirmar clínica (trismus, desviación de úvula, abombamiento), analgesia, hidratación y antibiótico.
- Tras drenaje: antibiótico (penicilina más metronidazol, clindamicina o amoxicilina-clavulánico) por 10-14 días.
- Hospitalizar si hay compromiso de vía aérea, deshidratación o mala respuesta; considerar amigdalectomía si recurre.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un joven de 20 años consulta por odinofagia izquierda de 4 días. No puede tragar su saliva y habla con voz apagada. Tiene 38,8 °C, trismus con apertura de 1,5 cm, abombamiento eritematoso del pilar anterior izquierdo y úvula desplazada hacia la derecha. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Penicilina benzatina intramuscular y control en 48 horas

B Punción con aguja gruesa o drenaje, antibiótico endovenoso y corticoide

C Radiografía lateral de cuello y alta con amoxicilina oral

D Amigdalectomía en caliente inmediata

E TAC de tórax ambulatorio

Respuesta B. Es un absceso periamigdalino con la tríada completa. Se confirma y alivia con punción o incisión y drenaje, más antibiótico endovenoso que cubra anaerobios y una dosis de corticoide. Con una colección purulenta no basta el tratamiento oral.

▶ VER CLASE 6.03.5.003 Drenaje de absceso retrofaríngeo

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.14 · Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

QUÉ HAY QUE SABER

- Drenaje transoral (bajo anestesia general, posición de Rose con cabeza colgando) o cervical externo si hay extensión lateral; lo realiza ORL.
- Indicado en colección retrofaríngea confirmada por TAC con contraste, o fracaso del antibiótico EV a las 48-72 horas.
- El riesgo principal es la aspiración del pus por ruptura y obstrucción de vía aérea: manejo en pabellón con intubación controlada.
- Previo a derivar: estabilizar vía aérea, hospitalizar, ayuno, hidratación y antibiótico EV (ampicilina-sulbactam o clindamicina).
- Complicaciones a vigilar: mediastinitis, trombosis yugular y extensión al espacio prevertebral.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 3 años con fiebre alta, odinofagia, sialorrea, rechazo alimentario y tortícolis con dolor a la extensión del cuello, tras una infección respiratoria alta. La radiografía lateral de cuello muestra aumento del espacio prevertebral. La TAC con contraste confirma una colección retrofaríngea con realce periférico de 2,5 cm. Respira sin dificultad. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Antibiótico oral y control ambulatorio

B Amigdalectomía de urgencia

C Punción del absceso en el servicio de urgencia por vía externa

D Corticoides y observación

E Hospitalización, antibióticos endovenosos y drenaje quirúrgico (habitualmente transoral) por otorrinolaringología, con protección de la vía aérea

Respuesta E. El absceso retrofaríngeo predomina bajo los 5 años, por supuración de ganglios retrofaríngeos: fiebre, odinofagia, tortícolis o limitación de la extensión y espacio prevertebral aumentado. Se hospitaliza con antibióticos endovenosos (amoxicilina-clavulánico o clindamicina) y, si hay colección significativa, se drena en pabellón por vía transoral con la vía aérea protegida.

▶ VER CLASE 6.03.5.004 Drenaje de hematoma nasoseptal

NIVEL **DERIVAR A ESPECIALISTA**

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.12 · Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal

QUÉ HAY QUE SABER

- Drenaje urgente para evitar necrosis del cartílago septal y deformidad en silla de montar.
- Técnica (por ORL): incisión mucopericondral, evacuación de coágulos y taponamiento anterior bilateral o sutura transfixiante.
- Indicar antibiótico antiestafilocócico (cefadroxilo, amoxicilina-clavulánico) mientras dure el taponamiento.
- El médico general debe reconocer el hematoma (abombamiento blando y violáceo del tabique) en todo trauma nasal y derivar el mismo día.
- Control en 24-48 horas para pesquisar recolección o absceso septal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Adolescente de 15 años recibe un golpe nasal jugando fútbol hace 24 horas. Presenta obstrucción nasal bilateral completa y dolor. La rinoscopía anterior muestra un abombamiento violáceo, blando y fluctuante a ambos lados del tabique. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Reducción de la fractura nasal en 7 días y antiinflamatorios

B Corticoide oral

C Descongestionante nasal y control en 48 horas

D Drenaje urgente del hematoma septal, taponamiento nasal anterior bilateral y antibiótico

E Esperar reabsorción espontánea

Respuesta D. El hematoma septal separa el mucopericondrio del cartílago, que depende de él para su nutrición. Sin drenaje urgente se produce necrosis del cartílago, absceso septal y deformidad en silla de montar. Se drena mediante incisión, se coloca taponamiento anterior para evitar la recolección y se indica antibiótico antiestafilocócico. Toda fractura nasal requiere examinar el tabique.

▶ VER CLASE 6.03.5.005 Drenaje de otohematoma

NIVEL **DERIVAR A ESPECIALISTA**

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.3 · Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado en hematoma del pabellón tras trauma; debe drenarse precozmente para evitar fibrosis y "oreja en coliflor".
- Técnica: punción-aspiración o incisión siguiendo los pliegues, en condiciones estériles, con evacuación completa del coágulo.
- Es esencial el vendaje compresivo o puntos de colchonero con almohadillas para evitar la recolección.
- Antibiótico profiláctico con cobertura antipseudomona (ciprofloxacino) y control en 24-48 horas.
- Derivar a ORL ante recurrencia, coágulos organizados o sospecha de pericondritis.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Se decide drenar en el servicio de urgencia un otohematoma de 12 horas de evolución en la cara anterior del pabellón auricular de un adulto. **¿Cuál es el paso más importante después de evacuar el contenido?**

A Aplicar un vendaje compresivo moldeado al relieve del pabellón (o puntos de colchonero con soporte) para evitar la recolección, y control en 24 a 48 horas

B Dejar el pabellón descubierto para vigilar

C Aplicar calor local

D Indicar gotas óticas

E Cerrar la incisión con sutura continua hermética sin compresión

Respuesta A. El drenaje del otohematoma se realiza con técnica aséptica, bajo anestesia local, mediante punción-aspiración o incisión siguiendo los pliegues del pabellón. Lo más importante después es la compresión moldeada (gasas, férulas o puntos de colchonero transfixiantes con rollos) para que el pericondrio vuelva a adherirse al cartílago y no se reacumule la sangre. Se controla precozmente y se considera antibiótico.

▶ VER CLASE 6.03.5.006 Extracción de cuerpo extraño del oído

NIVEL **DERIVAR A ESPECIALISTA**

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.18 · Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

QUÉ HAY QUE SABER

- Métodos: irrigación con agua tibia (solo objetos inertes no orgánicos y tímpano íntegro), pinza o gancho bajo visión directa, o aspiración bajo microscopio.
- Contraindicada la irrigación en pilas de botón, semillas o material vegetal y perforación timpánica.
- Insectos vivos: matarlos primero con aceite mineral o lidocaína.
- Objetos esféricos o impactados requieren gancho de punta roma o microscopio; múltiples intentos fallidos aumentan el riesgo de lesión.
- Derivar a ORL si falla un intento, hay lesión del conducto o el niño no coopera (puede requerir sedación).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 4 años con un poroto seco introducido en el conducto auditivo externo derecho hace 1 día. Coopera parcialmente. La otoscopía muestra el cuerpo extraño en la porción lateral del conducto, con tímpano no visible. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Lavado de oído con agua tibia a presión

B Extraerlo con pinza de punta lisa empujando hacia adentro

C Instilar gotas de agua para ablandarlo

D Extracción bajo visión directa con gancho o cureta, pasando por detrás del objeto, o derivar a ORL si no coopera o el objeto está en la porción medial

E Esperar expulsión espontánea

Respuesta D. Los cuerpos extraños del oído se extraen bajo visión directa con gancho o cureta pasado por detrás del objeto, con el niño inmovilizado o sedado. Las semillas y granos no se lavan con agua porque se hinchan. Las pinzas pueden empujar objetos redondos hacia el tímpano. Las pilas de botón son una urgencia.

▶ VER CLASE 6.03.5.007 Extracción de cuerpo extraño nasal

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.18 · Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

QUÉ HAY QUE SABER

- Preparar con vasoconstrictor y anestésico tópico, buena luz y especulo nasal; inmovilizar al niño.
- Técnica de presión positiva: un padre sopla en la boca del niño ocluyendo la fosa contralateral ("beso de la madre").
- Usar gancho romo pasado por detrás del objeto para traccionar hacia adelante; evitar pinza en objetos redondos.
- Pila de botón o imanes: extracción urgente por riesgo de perforación septal.
- Derivar a ORL si es posterior, no se visualiza bien o falla un intento (riesgo de aspiración a vía aérea).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 3 años con rinorrea purulenta, fétida y unilateral derecha de 2 semanas que no ha mejorado con antibióticos. A la rinoscopía anterior se ve un objeto plástico en la fosa nasal anterior derecha. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Repetir antibióticos por 10 días

B Extracción del cuerpo extraño bajo visión directa con gancho romo o pinza, previa vasoconstricción tópica, o con técnica de presión positiva ("beso de la madre"), derivando si no se logra

C Instilar suero para empujar el objeto hacia la faringe

D TAC de cavidades perinasales y control

E Lavado nasal a presión

Respuesta B. La rinorrea unilateral fétida en un niño es un cuerpo extraño nasal hasta demostrar lo contrario. Se extrae bajo visión directa con gancho romo o pinza, con vasoconstrictor tópico e inmovilización, o con presión positiva por la boca ocluyendo la fosa contralateral. Empujarlo hacia atrás arriesga aspiración. Pilas de botón e imanes son urgentes.

▶ VER CLASE 6.03.5.008 Intubacion traqueal

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: falla en proteger vía aérea (Glasgow ≤8), insuficiencia respiratoria refractaria, paro cardiorrespiratorio, inestabilidad o vía aérea amenazada.
- Preparación: preoxigenar con O2 al 100% 3-5 minutos, posición de olfateo, aspiración, laringoscopio, tubo con cuff (7-8 mujer, 8-8,5 hombre) y guía.
- Secuencia rápida: inductor (etomidato 0,3 mg/kg o ketamina 1-2 mg/kg) más relajante (succinilcolina 1-1,5 mg/kg o rocuronio 1,2 mg/kg).
- Confirmar posición con capnografía (estándar), auscultación de ambos campos y epigastrio, y radiografía de tórax.
- Si no se logra intubar ni ventilar: dispositivo supraglótico o cricotiroidotomía de urgencia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Se realiza intubación orotraqueal de un paciente con insuficiencia respiratoria en el servicio de urgencia. Tras pasar el tubo, se ausculta murmullo pulmonar solo en el hemitórax derecho y la capnografía muestra curva presente con valores adecuados. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Retirar el tubo y reintubar porque está en el esófago

B Mantener sin cambios

C Avanzar más el tubo

D Instalar drenaje pleural izquierdo de inmediato

E Desinflar el cuff y retirar el tubo unos centímetros hasta auscultar murmullo bilateral, y confirmar con radiografía de tórax

Respuesta E. La capnografía con curva persistente confirma ubicación traqueal. El murmullo solo derecho indica intubación selectiva del bronquio principal derecho por tubo muy profundo: se desinfla el cuff, se retira hasta lograr murmullo simétrico y se fija (adulto, unos 21 a 23 cm en la comisura). La radiografía confirma la punta 2 a 4 cm sobre la carina.

▶ VER CLASE 6.03.5.009 Laringoscopía indirecta

NIVEL **DERIVAR A ESPECIALISTA**

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.16 · Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke

QUÉ HAY QUE SABER

- Visualización de laringe e hipofaringe con espejo laríngeo y luz frontal; hoy reemplazada mayormente por nasofibroscopía.
- Indicaciones: disfonía >3 semanas, odinofagia o disfagia persistente, otalgia refleja, sospecha de cuerpo extraño o cáncer.
- Evalúa movilidad de cuerdas vocales, lesiones (nódulos, pólipos, leucoplasia, tumor) y senos piriformes.
- Contraindicada en sospecha de epiglotitis en niños por riesgo de laringoespasmo.
- El médico general debe derivar a ORL para el examen y emplear su informe.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 58 años, fumador, consulta en un servicio de urgencia rural por disfonía de 5 semanas. No hay nasofibroscopio disponible, por lo que decides examinar su laringe mediante laringoscopía indirecta con espejo laríngeo. **¿Cuál es la técnica correcta?**

A Paciente en decúbito supino con el cuello flectado y el espejo frío

B Pedir al paciente que trague durante el examen para ver las cuerdas vocales

C Introducir el espejo hasta apoyarlo en la pared posterior de la faringe para ver mejor

D Paciente sentado e inclinado hacia adelante, lengua traccionada con una gasa, espejo entibiado apoyado en la úvula y el velo, pidiéndole que diga «i»

E Si la laringoscopía indirecta es normal, se descarta un cáncer laríngeo y no requiere derivación

Respuesta D. En la laringoscopía indirecta el paciente se sienta erguido e inclinado hacia adelante; se tracciona la lengua con una gasa, se entibia el espejo para que no se empañe y se apoya en la úvula, sin tocar la faringe, para no gatillar náuseas. Al decir «i» las cuerdas se aducen. Una disfonía persistente en fumador igual se deriva a otorrinolaringología.

▶ VER CLASE 6.03.5.010 Lavado de oídos

NIVEL **REALIZAR**

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.3 · Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado para remover tapón de cerumen; antes, reblandecer con gotas (agua oxigenada diluida, bicarbonato o aceite) por 3-5 días.
- Contraindicaciones: perforación timpánica conocida o sospechada, cirugía de oído previa, otitis externa o media aguda, colleras, pilas o semillas.
- Técnica: agua a temperatura corporal (37 °C) para evitar vértigo calórico; traccionar el pabellón hacia arriba y atrás; dirigir el chorro a la pared posterosuperior.
- Detener si hay dolor, vértigo o sangrado; secar el conducto y revisar tímpano al finalizar.
- Complicaciones: perforación, otitis externa, vértigo; derivar si el tapón no sale o hay complicación.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 60 años con hipoacusia derecha de 1 semana. La otoscopía muestra un tapón de cerumen que ocluye el conducto. Se planifica lavado de oído. **¿Cuál de los siguientes antecedentes contraindica el lavado?**

A Antecedente de perforación timpánica o cirugía de oído

B Hipertensión arterial

C Uso de audífonos

D Edad mayor de 60 años

E Tapón de cerumen duro

Respuesta A. El lavado de oídos con agua a temperatura corporal (para no provocar vértigo) es eficaz para tapones de cerumen. Está contraindicado ante perforación timpánica conocida o sospechada, cirugía otológica previa, otitis con otorrea, cuerpos extraños vegetales o pilas. El cerumen duro se ablanda antes con gotas cerumenolíticas.

▶ VER CLASE 6.03.5.011 Maniobra de Heimlich

NIVEL **REALIZAR**

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.8 · Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicada en obstrucción completa de vía aérea por cuerpo extraño en consciente mayor de 1 año: no puede hablar, toser ni respirar, signo universal de asfixia.
- Si tose eficazmente: no intervenir, animar a toser.
- Técnica: por detrás, puño sobre el epigastrio (entre ombligo y apéndice xifoides), compresiones rápidas hacia adentro y arriba hasta expulsar o perder conciencia.
- Lactantes <1 año: 5 golpes en la espalda y 5 compresiones torácicas alternadas; embarazadas y obesos: compresiones torácicas.
- Si pierde la conciencia: iniciar RCP y revisar la boca antes de ventilar; no barrer a ciegas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 40 años se atraganta comiendo carne en un restaurante. Se lleva las manos al cuello, no puede hablar ni toser y se pone cianótico, pero sigue consciente. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Darle agua para que trague

B Barrido digital a ciegas

C Realizar compresiones abdominales subdiafragmáticas (maniobra de Heimlich) desde atrás, repetidas hasta expulsar el cuerpo extraño o que pierda la conciencia

D Esperar a que tosa espontáneamente

E Iniciar compresiones torácicas de inmediato aunque esté consciente

Respuesta C. Obstrucción grave de la vía aérea (no habla, no tose) en un adulto consciente: compresiones abdominales (Heimlich) desde atrás, con el puño sobre el epigastrio; algunas guías intercalan golpes interescapulares. En embarazadas y obesos, compresiones torácicas. Si pierde la conciencia, RCP. Si la tos es efectiva, solo estimularla. No hacer barrido digital a ciegas.

▶ VER CLASE 6.03.5.012 Taponamiento nasal anterior

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.11 · Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado en epistaxis anterior que no cede con compresión digital ni cauterización.
- Técnica: anestesia y vasoconstricción tópica, gasa con vaselina en capas desde el piso de la fosa, o tapón expansible (Merocel) lubricado.
- Mantener 48-72 horas; antibiótico profiláctico antiestafilocócico si se mantiene más de 48 horas (riesgo de shock tóxico).
- Si persiste sangrado hacia la faringe con tapón bien puesto: sospechar epistaxis posterior y realizar taponamiento posterior.
- Indicaciones al alta: no sonarse, evitar esfuerzos, controlar presión arterial, control en 48 horas para retiro.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 45 años consulta por epistaxis izquierda activa de 30 minutos. Está hemodinámicamente estable. Se realizó compresión bidigital por 15 minutos con la cabeza hacia adelante y luego se dejó un algodón con vasoconstrictor, pero persiste el sangrado y con espéculo nasal no se logra ubicar el vaso sangrante. No cae sangre por la orofaringe. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Cauterización a ciegas con nitrato de plata de ambos lados del tabique

B Ligadura quirúrgica de la arteria esfenopalatina

C Taponamiento posterior con sonda Foley

D Taponamiento nasal anterior con gasa vaselinada o Merocel por 48 horas

E Inclinar la cabeza hacia atrás y dar de alta

Respuesta D. Si la compresión y el vasoconstrictor fallan y no se ubica el vaso para cauterizarlo, sigue el taponamiento anterior: gasa orillada con vaselina en capas hacia el piso de la fosa nasal, o Merocel, por 48 horas, con control ambulatorio. El taponamiento posterior se reserva para cuando falla el anterior y la sangre cae a la faringe.

▶ VER CLASE 6.03.5.014 Taponamiento nasal posterior

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.11 · Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicado en epistaxis posterior que persiste pese a taponamiento anterior: sangrado a faringe, generalmente adulto mayor hipertenso.
- Técnica: sonda Foley (12-14 Fr) por la fosa hasta rinofaringe, inflar con 10-15 mL de agua o suero, traccionar hacia adelante y completar con taponamiento anterior.
- Fijar sin presión sobre el ala nasal (riesgo de necrosis); alternativa: balón de doble lumen.
- Hospitalizar: monitorizar oximetría (reflejo nasopulmonar e hipoventilación), antibiótico profiláctico, analgesia y control de PA.
- Retirar en 48-72 horas; si recurre, derivar a ORL para cauterización endoscópica o ligadura de esfenopalatina.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una paciente de 75 años con hipertensión arterial presenta epistaxis masiva que no cedió tras taponamiento anterior bilateral con Merocel, con sangrado activo y abundante por la faringe posterior. Se decide realizar taponamiento nasal posterior con sonda Foley. **Respecto al manejo integral de esta paciente, ¿cuál de las siguientes medidas es una indicación OBLIGATORIA?**

A Alta inmediata a domicilio con indicación de retirar la sonda Foley a las 12 horas.

B Hospitalización con monitorización de signos vitales e inicio de antibióticos profilácticos sistémicos.

C Insuflar el balón de la sonda Foley con 25 mL de aire para asegurar hemostasia máxima.

D Suspensión absoluta de toda hidratación parenteral y mantener presión arterial sistólica sobre 180 mmHg.

E Realizar cauterización a ciegas con nitrato de plata de la pared posterior de la orofaringe.

Respuesta B. El taponamiento posterior exige hospitalización con monitorización, por el riesgo de hipoxia, bradiarritmias por reflejo nasovagal y aspiración, y antibiótico profiláctico sistémico (amoxicilina con clavulánico o cefazolina) para prevenir shock tóxico estafilocócico y rinosinusitis. El balón se insufla con 8 a 10 mL de agua, nunca con aire.

▶ VER CLASE 6.03.5.015 Traqueostomía y cricoidostomía

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Cricotiroidotomía: vía aérea de emergencia ante situación "no intubo, no oxigeno"; se realiza a través de la membrana cricotiroidea.
- Por punción con aguja (preferida en menores de 10-12 años) o quirúrgica en adultos; es transitoria y debe convertirse a traqueostomía en 24-72 horas.
- Traqueostomía: procedimiento electivo para intubación prolongada (>7-14 días), obstrucción alta (tumor) o manejo de secreciones.
- Complicaciones: sangrado, enfisema subcutáneo, falsa vía, estenosis traqueal o subglótica.
- El médico general debe reconocer indicaciones y derivar; la traqueostomía la realiza el especialista.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 149

Paciente de 47 años con antecedente de neumonía grave por SARS-CoV-2 que requirió intubación y ventilación mecánica por 10 días evoluciona con dificultad respiratoria progresiva. Al examen físico presenta estridor bifásico, FC 110 lpm y FR aumentada a 20 rpm. La TAC de cuello muestra estenosis marcada de la vía aérea a nivel subglótico. **¿Cuál es la conducta más adecuada para su manejo actual?**

A Intubación orotraqueal

B Cricotirotomía

C Traqueostomía

D Oxigenoterapia por mascarilla de no recirculación

E Broncoscopía

Respuesta C. La estenosis subglótica posintubación con estridor y dificultad respiratoria progresiva requiere una vía aérea segura por debajo de la estenosis: traqueostomía. La intubación es difícil y puede empeorar la lesión al pasar por la zona estrecha, y la cricotirotomía se realiza a nivel de la membrana cricotiroidea, justo en la zona estenótica subglótica, y es solo un procedimiento de emergencia.

19 PEDIATRÍA

227 CÓDIGOS

486 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	142
Situaciones clínicas de urgencia	28
Conocimientos generales	19
Exámenes e imagenología	26
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	12

Situaciones clínicas

142 códigos

▶ VER CLASE **2.01.1.001** **Desnutrición**

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.1 · Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Desnutrición: evaluar con curvas OMS; <2 años P/E y P/T, ≥2 años IMC/E; T/E < -2 DE indica talla baja (desnutrición crónica).
- Clasificación: riesgo de desnutrir P/T o IMC/E entre -1 y -2 DE; desnutrición < -2 DE. Marasmo (déficit calórico, emaciado) vs Kwashiorkor (déficit proteico, edema, hipoalbuminemia).
- Estudio: encuesta alimentaria, hemograma, albúmina, orina completa/urocultivo, parasitológico; buscar causa secundaria (celiaquía, FQ, cardiopatía, negligencia).
- Tratamiento: realimentación gradual con aporte calórico-proteico aumentado, suplemento de hierro, zinc y vitaminas; tratar la causa e incorporar al PNAC.
- Grave: riesgo de síndrome de realimentación (hipofosfemia, hipokalemia), hipoglicemia e hipotermia; hospitalizar si hay edema, compromiso general o infección.
- Seguimiento: control nutricional mensual con curva de peso y talla en APS; derivar si no hay recuperación o se sospecha causa orgánica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niña de 3 años, traída a control. Ha tenido diarreas a repetición los últimos 2 meses. En las curvas OMS: Peso para la Edad −2,4 DE, Talla para la Edad −1,3 DE y Peso para la Talla −2,1 DE. **¿Cuál es su diagnóstico nutricional?**

A Desnutrición

B Riesgo de desnutrición

C Eutrófica con talla normal

D Talla baja

E Desnutrición crónica con talla baja

Respuesta A. En menores de 5 años el diagnóstico nutricional lo define el Peso para la Talla: −2 DE o menos es desnutrición. La Talla para la Edad en −1,3 DE está en rango normal, así que no hay talla baja. El Peso para la Edad no define el diagnóstico.

▶ VER CLASE **2.01.1.002** **Dislipidemias**

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.4 · Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

QUÉ HAY QUE SABER

- Dislipidemia pediátrica: tamizaje universal con perfil lipídico entre 9-11 años y 17-21; selectivo desde 2 años si hay historia familiar de ECV precoz o hipercolesterolemia, obesidad, DM o HTA.
- Valores aceptables: CT <170 mg/dL, LDL <110, TG <75 (<10 años) o <90 (10-19 años), HDL >45. LDL ≥130 alterado; LDL ≥190 sugiere hipercolesterolemia familiar.
- Confirmar con 2 perfiles en ayuno; descartar causas secundarias: obesidad, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, colestasia, fármacos (corticoides, isotretinoína).
- Tratamiento inicial: dieta (grasa total 25-30%, saturada <7%, sin trans), actividad física ≥60 min/día y manejo del peso por 6-12 meses.
- Estatinas desde los 8-10 años si LDL persiste ≥190 mg/dL, o ≥160 con factores de riesgo, tras fallar dieta: lo indica el especialista.
- Seguimiento: derivar a nutriología/endocrinología infantil; estudio en cascada de familiares si hay hipercolesterolemia familiar.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 11 años es derivado por colesterol LDL de 205 mg/dL, confirmado en dos mediciones. Su padre tuvo un infarto agudo al miocardio a los 42 años. Lleva 6 meses con dieta y actividad física supervisadas, con LDL de control de 198 mg/dL. Su IMC es normal y no tiene otras enfermedades. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener solo dieta y controlar en un año

B Indicar suplementos de omega 3 como única medida

C Iniciar fibratos

D Esperar hasta los 18 años para iniciar fármacos

E Iniciar una estatina en dosis baja manteniendo la dieta

Respuesta E. LDL de 190 mg/dL o más persistente tras 6 meses de dieta, en un niño de 10 años o más, sugiere hipercolesterolemia familiar y es indicación de estatina, sobre todo con antecedente de enfermedad coronaria precoz. Se inicia en dosis baja, manteniendo cambios de estilo de vida y vigilando CK y transaminasas. Los fibratos son para hipertrigliceridemia.

▶ VER CLASE 2.01.1.003 Obesidad

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Pediatría 18.1 · Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Obesidad: <5 años P/T > +2 DE (sobrepeso +1 a +2); ≥5 años IMC/E ≥ +2 DE (≥p95 en CDC), sobrepeso +1 a +2 DE. Perímetro de cintura ≥p90 = obesidad abdominal.
- Buscar comorbilidad: HTA, acantosis nigricans (resistencia insulínica), dislipidemia, hígado graso (ALT), apnea del sueño, epifisiólisis, SOP, impacto psicosocial.
- Sospechar causa endocrina o genética si hay talla baja con obesidad (hipotiroidismo, Cushing, déficit de GH) o dismorfias/retraso (Prader-Willi).
- Exámenes en obesidad: glicemia ayuno, perfil lipídico, transaminasas; insulinemia/PTGO si acantosis o antecedentes familiares de DM2.
- Tratamiento: cambio de estilo de vida familiar, dieta saludable sin bebidas azucaradas, ≥60 min/día de actividad física, pantallas <2 h/día; meta en niño pequeño mantener peso mientras crece.
- Seguimiento: controles mensuales en APS con equipo (nutricionista, psicólogo); derivar si comorbilidad grave, sospecha de causa secundaria o falla del manejo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 7 años, en control de salud. Toma 2 vasos de bebida azucarada al día y juega pocas horas al aire libre. En las curvas OMS: Talla para la Edad +0,5 DE e IMC para la Edad +2,4 DE. Su Peso para la Talla calculado por la madre en una aplicación es +1,6 DE. **¿Cuál es su diagnóstico nutricional?**

A Eutrófico

B Sobrepeso, según el Peso para la Talla

C Obesidad

D Obesidad severa

E Talla alta constitucional

Respuesta C. Desde los 5 hasta los 19 años se usa el IMC para la Edad, no el Peso para la Talla. Entre +2 y +2,9 DE corresponde a obesidad; la obesidad severa parte en +3 DE. Usar el Peso para la Talla a esta edad lleva al error de diagnosticar sobrepeso.

▶ VER CLASE 2.01.1.004 Adenitis cervical

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Otorrino 14.20 · Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

QUÉ HAY QUE SABER

- Adenitis cervical aguda: ganglio >2 cm, doloroso, eritematoso, unilateral, generalmente por S. aureus o S. pyogenes, en preescolares tras infección respiratoria.
- Bilateral y pequeña: reactiva viral (sin antibiótico). Fluctuación indica absceso (confirmar con ecografía).
- Tratamiento empírico: cefadroxilo 50 mg/kg/día c/12 h o amoxicilina-ácido clavulánico por 10 días; hospitalizar si tóxico, <1 año o sin respuesta en 48-72 h (cloxacilina/cefazolina EV).
- Absceso: drenaje quirúrgico. Subaguda/crónica: pensar en micobacterias atípicas, enfermedad por arañazo de gato (Bartonella: azitromicina), TBC o toxoplasmosis.
- Banderas rojas de neoplasia: ganglio supraclavicular, duro, adherido, >3 cm, sin respuesta a 2-4 semanas, síntomas B o hepatoesplenomegalia: hemograma, Rx tórax y derivar para biopsia.
- Seguimiento: control a las 48-72 h y al terminar el tratamiento hasta la regresión del ganglio.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 142

Un escolar de 6 años presenta aumento de volumen submandibular derecho, doloroso. Al examen físico se aprecia dicho aumento de volumen, de aspecto eritematoso, de 3 cm de diámetro, doloroso a la palpación. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Bacteroides fragilis

B Peptoestreptococo

C Streptococcus pyogenes (grupo A)

D Staphylococcus aureus

E Escherichia coli

Respuesta D. Una adenitis cervical aguda unilateral, eritematosa y dolorosa en un niño es una adenitis bacteriana piógena. Los agentes son Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes; cuando el ganglio está inflamado y tiende a abscedarse, el más probable es S. aureus. Se trata con cefadroxilo o cloxacilina y drenaje si fluctúa.

▶ VER CLASE 2.01.1.005 Celulitis periorbitaria

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Oftalmología 15.17 · Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC

Otorrino 14.10 · Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

QUÉ HAY QUE SABER

- Celulitis preseptal (periorbitaria): edema y eritema palpebral sin compromiso del globo; motilidad ocular, agudeza visual y pupilas normales. Origen cutáneo (picadura, herida) o sinusal.

- Celulitis orbitaria (postseptal): proptosis, oftalmoplejía dolorosa, disminución de agudeza visual, quemosis; complicación de sinusitis etmoidal. Es urgencia: TC de órbita y senos con contraste.
- Preseptal leve en niño >1 año con buen estado: amoxicilina-ácido clavulánico 80-90 mg/kg/día o cefadroxilo por 7-10 días con control en 24-48 h.
- Hospitalizar con antibiótico EV (ceftriaxona + cloxacilina, o clindamicina) si orbitaria, <1 año, compromiso general, sin respuesta oral o duda diagnóstica.
- Complicaciones de la orbitaria: absceso subperióstico, trombosis del seno cavernoso, meningitis, pérdida visual.
- Seguimiento: derivar a oftalmología y otorrinolaringología toda celulitis orbitaria o la preseptal que no responde.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 122

Una niña de 4 años presenta un cuadro catarral, con abundante rinorrea. Evoluciona con eritema y dolor periocular derecho, asociado a proptosis. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Celulitis preorbitaria
B Celulitis orbitaria
C Orbitopatía distiroidea
D Pseudotumor orbitario
E Etmoiditis aguda

Respuesta B. La proptosis es la que define el compromiso orbitario, y por eso la respuesta es celulitis orbitaria. Es secundaria a la sinusitis que acompaña al cuadro catarral, casi siempre etmoidal en una niña de esta edad. La celulitis preseptal, por definición, no da proptosis.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 7 años tiene 6 días de rinorrea mucopurulenta y congestión nasal, tratados como resfrío. En las últimas 24 horas presenta fiebre de 39,4 °C y tumefacción progresiva del ojo izquierdo. Tiene edema y eritema palpebral marcado, proptosis evidente y limitación muy dolorosa de la abducción y la elevación de ese ojo. La agudeza visual está conservada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Amoxicilina oral ambulatoria y control en 48 horas
B Descongestionante tópico y paracetamol
C Radiografía de senos paranasales y alta
D Hospitalizar, solicitar TAC de senos y órbitas con contraste e iniciar antibióticos endovenosos
E Solo lavados nasales con suero fisiológico

Respuesta D. La proptosis y la oftalmoplejía dolorosa indican celulitis orbitaria (Chandler II), una emergencia por el riesgo de absceso, amaurosis y trombosis del seno cavernoso. Se hospitaliza, se toman hemocultivos, se pide TAC con contraste y se inicia ceftriaxona endovenosa con vancomicina o clindamicina.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 6 años, con antecedente de picadura de insecto en el párpado hace 2 días, consulta por edema y eritema palpebral derecho, con fiebre de 38,2 grados. Los movimientos oculares están conservados, sin dolor al moverlos, no hay proptosis y la agudeza visual es 20/20 en ambos ojos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Hospitalizar de inmediato e iniciar ceftriaxona más vancomicina endovenosas
B Solicitar tomografía computada de órbita antes de definir el tratamiento
C Iniciar amoxicilina con ácido clavulánico oral en forma ambulatoria, con control clínico en 24 horas
D Indicar corticoides orales en dosis altas para bajar el edema
E Derivar de urgencia a neurocirugía por sospecha de trombosis del seno cavernoso

Respuesta C. La motilidad ocular conservada e indolora, la ausencia de proptosis y la agudeza visual normal descartan compromiso orbitario y confirman una celulitis preseptal secundaria a la picadura. El manejo es ambulatorio con amoxicilina y ácido clavulánico oral, con control a las 24 horas; ni la hospitalización ni la tomografía son necesarias de entrada.

▶ VER CLASE 2.01.1.006 Coqueluche

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.5 · Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Coqueluche (Bordetella pertussis): fase catarral (1-2 sem), paroxística con tos en accesos, estridor inspiratorio («gallito»), vómitos post-tos y cianosis; convaleciente semanas.
- Lactante <3 meses: presentación atípica con apneas y cianosis sin gallito; alto riesgo de muerte (hipertensión pulmonar). Hemograma con leucocitosis y linfocitosis marcada.
- Confirmar con PCR para B. pertussis en hisopado nasofaríngeo. Es de notificación obligatoria inmediata.
- Tratamiento: azitromicina 10 mg/kg/día por 5 días (en <1 mes preferida); alternativas claritromicina 7 días o cotrimoxazol >2 meses. Antibiótico no acorta la tos pero corta el contagio.
- Hospitalizar a todo <3 meses o con apneas, cianosis, dificultad para alimentarse o hiperleucocitosis. Quimioprofilaxis con azitromicina a contactos estrechos, priorizando lactantes y embarazadas.
- Prevención: vacuna hexavalente (2-4-6-18 meses), dTpa en 1º y 8º básico y dTpa a la embarazada desde las 28 semanas. Seguimiento: control hasta resolución de los paroxismos.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 72

Un recién nacido de 2 semanas es hospitalizado por presentar apneas. La madre refiere tos de 3 semanas de evolución, en crisis, que en ocasiones la hace vomitar. **¿Cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?**

A Amoxicilina
B Azitromicina
C Ceftriaxona
D Oseltamivir
E Aciclovir

Respuesta B. Apneas en un recién nacido con una madre con tos paroxística emetizante de 3 semanas sugieren coqueluche (Bordetella pertussis). El tratamiento es un macrólido; en menores de 1 mes se prefiere azitromicina por el menor riesgo de estenosis hipertrófica del píloro. Se confirma con PCR y se trata también a los contactos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 151

Un paciente de 13 meses, es traído por presentar desde hace 4 días cuadro caracterizado por crisis de tos que aparecen de forma repetitiva durante el día, asociado a decaimiento, rechazo alimentario, náuseas y vómitos. Al examen físico se aprecia hemorragia subconjuntival derecha, examen pulmonar con murmullo pulmonar presente, sin otros hallazgos. El agente etiológico más probable en este caso es:

A Virus respiratorio sincicial
B Virus parainfluenza
C Mycoplasma
D Bordetella pertusis
E Virus sarampión

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Bordetella pertusis). Es un coqueluche de libro. El coqueluche (tos ferina o tos compulsiva) es una enfermedad incluida en el Plan Nacional de Inmunizaciones causada por Bordetella pertussis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 40

Un recién nacido de 3 semanas de vida es hospitalizado por presentar apneas. La madre refiere tos frecuente de 2 semanas de evolución, intensa, que en ocasiones la hacen vomitar. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?

A Amoxicicilina
B Azitromicina
C Ceftriaxona
D Oseltamivir
E Aciclovir

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Azitromicina (opción B). La sospecha es un coqueluche, que se trata con macrólidos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 151

Un niño de 5 meses de edad presenta un cuadro de rinorrea y tos, que va en aumento, hasta presentar accesos de tos y dificultar la alimentación. Al examen físico está en buenas condicioness generales, afebril y sin alteraciones en el examen cardiopulmonar. Se solicita un hemograma, que muestra leucocitosis de 17.000, con 78% de linfocitos y 22% de neutrófilos. La PCR y VHS están levemente elevadas. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un patrón intersticial leve. El diagnóstico más probable es:

A Neumonía atípica
B Infección por virus influenza
C Infección por adenovirus
D Coqueluche
E Bronquiolitis aguda

Respuesta D. Es un coqueluche clásico: tos en accesos, precedido por cuadro catarral y linfocitosis en el hemograma.

▶ VER CLASE **2.01.1.007** **Enteroparasitosis** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.1 · Diarrea Aguda y Crónica en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Enteroparasitosis más frecuentes en Chile: Giardia lamblia (diarrea crónica, malabsorción, distensión), Oxiuros (prurito anal nocturno), Blastocystis y Ascaris.
- Diagnóstico: parasitológico seriado de deposiciones (3 muestras); test de Graham (cinta adhesiva perianal matinal) para Enterobius vermicularis.
- Giardiasis: metronidazol 15 mg/kg/día por 5-7 días, o tinidazol 50 mg/kg dosis única, o nitazoxanida.
- Oxiuriasis: mebendazol 100 mg dosis única o albendazol 400 mg (200 mg <2 años), repetir a las 2 semanas; tratar a todo el grupo familiar y lavar ropa de cama.
- Ascaris y otros helmintos: albendazol 400 mg dosis única o mebendazol 100 mg c/12 h por 3 días. Teniasis: praziquantel.
- Prevención: lavado de manos, agua potable, lavado de verduras, cocción de carnes. Seguimiento: parasitológico de control post tratamiento si persisten síntomas.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 120

Un niño de 4 años presenta intenso prurito anal desde hace varios días, lo que se ha asociado a dificultades para dormir y bruxismo. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A Parasitológico de deposiciones
B Test de Graham
C Hemograma
D Prueba de reacción cutánea (prick test)
E Recuento de inmunoglobulina E específica

Respuesta B. Prurito anal nocturno con trastornos del sueño y bruxismo en un preescolar sugiere oxiuriasis (Enterobius vermicularis). La hembra deposita los huevos en la piel perianal, por lo que no suelen aparecer en las deposiciones; el examen de elección es el test de Graham (cinta adhesiva perianal en la mañana).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 125

Una niña de 5 años persenta prurito anal importante, asociado a prurito vulvar. La madre refiere que también presenta bruxistmo. Al examen físico presenta signos de grataje en la zona perianal y perivulvar. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A Parasitológico seriado
B Test de Graham
C Microscopía óptica de frotis directo de deposiciones
D Coprocultivo
E Medición de eosinófilos en sangre

Respuesta B. Diagnóstico: Test de Graham (opción B). La oxiuriasis se diagnostica con el test de Graham.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 143

Un niño de 7 años es llevado a consulta por prurito anal intenso, mayor en las noches, de 2 semanas de evolución. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones generales, con signos vitales y examen abdominal normales. El examen anal no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada para continuar el estudio de este paciente?

A Colonoscopía
B Examen directo de heces
C Examen parasitológico de deposiciones
D Test de Graham
E Serología para Enterobius vermicularis

Respuesta D. Diagnóstico de Enterobiasis: El test de Graham es el examen de elección para diagnosticar enterobiasis (oxiuariasis). Recolecta los huevos del parásito en la zona perianal, utilizando una cinta adhesiva, con mayor efectividad que los análisis parasitológicos convencionales.

▶ VER CLASE `2.01.1.008` **Escarlatina** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Infectología 5.3 · Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki
Pediatría 18.10 · Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)

QUÉ HAY QUE SABER

- Escarlatina: exantema por toxina eritrogénica de S. pyogenes en faringoamigdalitis; 3-15 años. Exantema micropapular áspero (piel de lija) que respeta el surco nasogeniano.
- Signos clave: lengua aframbuesada, palidez peribucal (Filatov), líneas de Pastia en pliegues, descamación furfurácea/en guante a la semana.
- Diagnóstico clínico; test rápido de antígeno o cultivo faríngeo si hay dudas.
- Tratamiento: penicilina benzatina 600.000 UI IM (<27 kg) o 1.200.000 UI (≥27 kg) dosis única, o amoxicilina 50 mg/kg/día por 10 días; alergia a penicilina: azitromicina 5 días.
- Complicaciones: fiebre reumática (prevenible con antibiótico iniciado hasta 9 días), glomerulonefritis postestreptocócica (no prevenible), absceso periamigdalino.
- Seguimiento: control clínico al terminar tratamiento; orina completa si aparecen edema, hematuria o HTA a las 1-3 semanas. Retorno al colegio tras 24 h de antibiótico.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 71

Un niño de 7 años, consulta por fiebre, malestar general y dolor de garganta, a lo que se le agregó un exantema. Al examen físico presenta adenopatías cervicales anteriores sensibles y un rash generalizado, mayor en los pliegues de los codos y axilas. La piel se palpa áspera. **¿Cuál es el agente más probable?**

A Virus de Ebstein Baar
B Virus sarampión
C Estreptococo betahemolítico grupo A
D Virus rubéola
E Estafilococo aúreo

Respuesta C. Faringitis con adenopatías cervicales anteriores y exantema áspero acentuado en pliegues (líneas de Pastia): escarlatina por Streptococcus pyogenes. Se trata con amoxicilina por 10 días.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 96

Niño de 6 años con odinofagia intensa, fiebre y decaimiento. Luego aparece un exantema eritematoso generalizado, más marcado en los pliegues inguinales y axilares. Al examen: febril, faringe eritematosa, adenopatías cervicales sensibles, y piel áspera al tacto. **¿Qué complicación puede desarrollar este paciente?**

A Aneurismas coronarios
B Meningitis
C Fascitis necrotizante
D Glomerulonefritis
E Miocarditis

Respuesta D. Es un cuadro de escarlatina (odinofagia, fiebre, exantema en piel de lija más marcado en pliegues). La complicación que puede aparecer, incluso tratada, es la glomerulonefritis postestreptocócica; el antibiótico previene la fiebre reumática, pero no esta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 48

Un paciente de 6 años, con historia de 5 días de odinofagia intensa asociada a secreción purulenta y sensación febril que durante el último día se acompañó de rash papular eritematoso que es más intenso en pliegues. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

A Hemograma
B IgM para virus Epstein barr
C Panel viral
D Cultivo de secreción faríngea
E Test pack para Streptococo grupo A

Respuesta D. Es una escarlatina y el diagnóstico es clínico. No hay que pedir ningún examen, por lo que esta pregunta está técnicamente mala. El cultivo faríngeo es el goldstandard, pero demora. La verdad es que no estoy 100% seguro de que esta sea la respuesta correcta, ya que al igual que en el Herpes, el diagnóstico es clínico y el gold standard es el cultivo. Eso sí, el test pack tiene el resultado es inmediato y hay que iniciar antibióticos ahora (de hecho hay que iniciarlos porque ya está hecho el...

▶ VER CLASE 2.01.1.009 **Exantemas virales**

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Infectología 5.3 · Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki
Pediatría 18.10 · Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sarampión: fiebre alta, tos, coriza, conjuntivitis, manchas de Koplik y exantema maculopapular céfalo-caudal confluente. Notificación inmediata; vacuna SRP.
- Rubéola: exantema rosado leve, adenopatías retroauriculares y occipitales; riesgo de rubéola congénita. Eritema infeccioso (parvovirus B19): mejillas abofeteadas y exantema en encaje; aplasia en anemias hemolíticas.
- Exantema súbito (VHH-6): lactante con 3-5 días de fiebre alta y exantema al desaparecer la fiebre; puede dar convulsión febril.
- Varicela: exantema polimorfo pruriginoso «en cielo estrellado» (mácula, pápula, vesícula, costra), compromete mucosas. Aciclovir 80 mg/kg/día en 4 dosis por 5 días en >12 años, inmunodeprimidos o enfermedad cutánea/pulmonar crónica.
- Enfermedad mano-pie-boca (coxsackie): vesículas orales y en palmas/plantas. Manejo sintomático con paracetamol; evitar aspirina (síndrome de Reye) e ibuprofeno en varicela (fascitis).
- Seguimiento: control si sobreinfección bacteriana o signos de complicación (neumonía, encefalitis, ataxia cerebelosa en varicela).

PREGUNTAS · 18

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 23

Un lactante de 10 meses de edad presenta eritema en la cara, que al día siguiente se generaliza. Al examen físico tiene un exantema rosado macular tenue, asociado a adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores. **El diagnóstico más probable es:**

A Eritema infeccioso
B Rubéola
C Exantema por citomegalovirus
D Sarampión
E Exantema súbito

Respuesta B. Exantema macular rosado tenue de progresión rápida con adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores: rubéola. Con menos de un año, aún no recibe la vacuna tresvírica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 127

Un prescolar de 4 años presenta un cuadro de fiebre hasta 38 grados, asociado a eritema en las mejillas, que aumenta en los periodo de fiebre y con el calor y se vuelve más pálido cuando no hay fiebre. Luego se agrega un exantema reticular en el tronco. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Virus rubéola
B Virus Coxsackie
C Parvovirus B19
D Streptococcus pyogenes
E Virus herpes 6

Respuesta C. Eritema de mejillas (signo de la bofetada) que se acentúa con el calor, seguido de exantema reticular en el tronco: eritema infeccioso por parvovirus B19.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 25

Un niño de 5 años presenta un exantema pruriginoso, desde hace 4 días, generalizado y pleomorfo, consistente en máculas, pápulas, vesículas, que inició en el cuero cabelludo y luego se extendió al tronco y las extremidades. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Aciclovir
B Valaciclovir
C Prednisona
D Clorfenamina maleato
E Talco mentolado

Respuesta D. Varicela clásica no complicada en un niño sano: tratamiento sintomático, con antihistamínico para el prurito. El antiviral se reserva para mayores de 13 años, el segundo caso intradomiciliario, los cuadros graves o los inmunodeprimidos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 13

Lactante de 8 meses con fiebre de 39,5 °C durante 5 días. Al sexto día la fiebre cede y aparece un exantema rosado generalizado no pruriginoso. El niño está en buen estado general. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Control sano habitual: es un exantema súbito, de evolución benigna
B Derivar a especialista de inmediato
C Hospitalizar para estudio
D Iniciar aciclovir oral
E Solicitar serología viral urgente

Respuesta A. Fiebre alta de varios días que cede bruscamente, seguida de exantema rosado en un lactante con buen estado general: exantema súbito por HHV-6. Es diagnóstico clínico, autolimitado, y no requiere estudio ni antiviral.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 37

Niño de 5 años con fiebre baja hasta 37,5 °C y eritema malar. Dos días después se agrega un exantema eritematoso macular en el tronco y las extremidades, con un cuadro que dura un total de 10 días. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Streptococcus pyogenes
B Parvovirus B19
C Virus de Epstein-Barr
D Virus herpes humano número 6
E Virus rubéola

Respuesta B. Eritema malar (signo de la bofetada) seguido de exantema reticular en tronco y extremidades, con fiebre baja y curso prolongado, es el cuadro clásico del eritema infeccioso por Parvovirus B19.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 70

Un niño de 18 meses lleva 3 días con fiebre, cuantificada de 38,8°. Se inicia amoxicilina, desapareciendo la fiebre y apareciendo un exantema eritematoso generalizado, que se muestra en la siguiente imagen: Foto 6 (http://www.childnurture.com/article/XXXXXXX) ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Eritema infeccioso
B Exantema súbito
C Reacción alérgica a medicamentos
D Enfermedad de Kawasaki
E Síndrome de piel escaldada

Respuesta B. Diagnóstico: Exantema súbito (opción B). Es un exantema súbito clásico, por virus herpes 6.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 52

Un lactante de 14 meses de edad presenta un cuadro febril de 4 días de evolución, con fiebre hasta 39,2°C, la que desaparece abruptamente, dado paso a la aparición de un rash eritematoso maculopapular, que afecta la cara, el tronco y las cuatro extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Eritema infeccioso
B Síndrome de pie mano boca
C Síndrome de Kawasaki
D Exantema súbito
E Rubéola

Respuesta D. Exantema súbito (Roséola infantil): Es un exantema súbito clásico, que afecta principalmente a niños entre 6 y 12 meses de edad. Se caracteriza por una fiebre muy alta que cesa repentinamente, seguida de la aparición de un rash generalizado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 35

Un niño de 18 meses presenta, desde hace 5 días irritabilidad y fiebre, cuantificada hasta 38,8°. Se inicia amoxicilina, cediendo la fiebre fiebre hace 48 horas y apareciendo un exantema eritematoso generalizado hace 24 horas, que se muestra en la siguiente imagen (fuente: wikipedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Eritema infeccioso
B Exantema súbito
C Reacción cutánea a medicamentos
D Enfermedad de Kawasaki
E Rubéola

Respuesta B. Diagnóstico: Exantema súbito (opción B). Es un exantema súbito clásico. También se llama sexta enfermedad o roséola.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 69

Un niño de 5 años, es traído por su madre, por fiebre hasta 38,0°C y aparición de eritema facial marcado, que luego desaparece, dando paso a aparición de un exantema “en encaje”, que afecta el abdomen, las extremidades superiores y las extremidades inferiores, el que ha persistido por 15 días. Ha recibido ibuprofeno para sus síntomas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Rubéola
B Infección por virus Coxsackie A16
C Infección por parvovirus B19
D Reacción adversa al ibuprofeno
E Mononucleosis infecciosa

Respuesta C. Diagnóstico: Infección por parvovirus B19 (opción C). Es un eritema infeccioso clásico. El exantema puede durar hasta 30 días.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 139

Un niño de 5 años presenta fiebre no cuantificada, asociada a un exantema que inicia en las mejillas y que luego se extiende a la zona proximal de las extremidades, con una disposición, en encaje. Al examen físico tiene 37,1 grados de temperatura y se aprecia la faringe congestiva, con amígdalas rosadas y el exantema descrito. El diagnóstico más probable es:

A Exantema súbito
B Eritema infeccioso
C Exantema por virus Coxsackie
D Rubéola
E Escarlatina

Respuesta B. Diagnóstico: Eritema infeccioso (opción B). Es un eritema unfeccioso clásico, por PVB19.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 27

Un lactante de 10 meses de edad, presenta un cuadro de fiebre hasta 37,8 grados Celsius, asociado a aparición de un exantema generalizado, de timo macular eritematoso, de aspecto tenue. Al examen físico destacan adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores, sensibles a la palpación. El diagnóstico más probable es:

A Exantema súbito
B Eritema infeccioso
C Rubeola
D Sarampión
E Exantema por citomegalovirus

Respuesta C. Es una rubeola clásica (exantema macular tenue y generalizado, con adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores). Por tener menos de 1 años, aún no recibe la trivírica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 132

Un niño de 5 años de edad presenta fiebre leve, asociada a eritema malar, que dura 2 días y luego cede. Al cuarto día aparece un exantema que afecta el tronco y las zonas extensoras de las extremidades. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A Virus herpes 6
B Virus rubeola
C Virus sarampión
D Parvovirus B19
E Streptococcus pyogenes

Respuesta D. Pregunta muy mal intencionada. El VH6 produce exantema súbito, pero habitualmente entre los 6 y 18 meses y con fiebre alta (cercana a 40 grados). El PVB19 produce el eritema infeccioso o quinta enfermedad, que produce el eritema malar (signo de la cachetada) y el exantema con esa distribución. Afecta a escolares con mayor frecuencia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 168

Niño con historia de malestar general y fiebre 37.5°C-37.9°C de una semana de evolución, manejado con ibuprofeno. Le aparecia rash eritematoso en mejillas y Extremidades:

A Eritema infeccioso
B RAM
C KAWASAKI
D Control sano habitual
E Derivar a especialista

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Eritema infeccioso).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 131

Paciente de 3 años de edad, previamente sano, hace dos días inicia cuadro caracterizado por fiebre intensa, cuantificada hasta 39ºC, no asociado a otros síntomas. Su madre le administra acetaminofeno por vía oral durante el primer día, tras lo cual evoluciona con disminución de la fiebre y hoy amanece con exantema maculopapular no pruriginoso, sin fiebre y en buenas condiciones. El agente etiológico más probable es:

A Citomegalovirus
B Virus Epstein barr
C Virus Herpes 6
D Parvovirus B19
E Enfermedad de Still

Respuesta C. Tiene un exantema súbito clásico, aunque está muy grande para tenerlo (suele ser en menores de dos años)

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 30

Niña escolar con fiebre y exantema en mejillas y tronco (aspecto de 'bofetada'). ¿Cuál es el agente más probable?

A Virus del sarampión
B Virus de la rubéola
C Herpes virus 6
D Enterovirus
E Parvovirus B19

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Parvovirus B19). Parvovirus B19.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 32

Una niña de 4 años es traída por un cuadro de 3 días de evolución de malestar general, fiebre hasta 38,5°C y, el día de hoy, aparición de un lesiones cutáneas que abarcan tronco extremidades y cara, como se muestra en la imagen (fuente: dortorgo.es): ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A Virus rubéola
B Parvovirus B19
C Coxsackie A16
D Virus herpes simple
E Virus herpes 6

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Coxsackie A16).

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 31

Lactante menor con fiebre alta; cuando cede aparece rash maculopapular en tronco y extremidades. ¿Cuál es el agente más probable?

A Parvovirus B19
B Enterovirus
C Virus herpes 6
D Adenovirus
E Virus varicela-zóster

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Virus herpes 6). Virus herpes 6.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 43

Un niño de 11 meses de edad presenta fiebre hasta 39°C, desde hace 3 días, asociado a irritabilidad, que ha sido manejeada con paracetamol. El día de hoy presenta lesiones cutáneas papulares eritematosas, generalizadas. El resto de su examen físico no tiene alteraciones ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A Virus herpes 6
B Parvovirus B19
C Virus Coxsackie A16
D Virus varicela zóster
E Virus de Epstein Baar

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Virus de Epstein Baar).

▶ VER CLASE 2.01.1.010 Hepatitis viral

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 3.2 · Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Hepatitis A: la más frecuente en niños, transmisión fecal-oral; en menores casi siempre asintomática o leve; ictericia, coluria, acolia, transaminasas >10 veces.
- Diagnóstico: IgM anti-VHA confirma infección aguda. Hepatitis B: HBsAg y anti-HBc IgM; VHB adquirido perinatal cronifica en ~90%.
- Manejo VHA: sintomático, reposo relativo, dieta habitual, evitar paracetamol en exceso y hepatotóxicos; no requiere antiviral.
- Banderas rojas de falla hepática: TP <50% / INR >1,5 que no corrige con vitamina K, encefalopatía, hipoglicemia: hospitalizar y derivar a centro con trasplante.
- Prevención: vacuna hepatitis A a los 18 meses (PNI) y hepatitis B al nacer + hexavalente. RN de madre HBsAg+: vacuna e inmunoglobulina en <12 h.
- Seguimiento: control clínico y de transaminasas/TP hasta normalización; contactos domiciliarios sin vacunar pueden recibir vacuna VHA post exposición.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 79

Adolescente de 15 años con cuadro de 5 días de evolución con fiebre, astenia, náuseas e ictericia, a lo que últimamente se ha agregado prurito. Ha tomado paracetamol (500 mg), un total de 6 tabletas. Al examen físico, hipocondrio derecho levemente sensible a la palpación. Tiene antecedente de haber estado en un campamento hace 1 mes. En sus exámenes: fosfatasas alcalinas y GGT 8 veces sobre el valor normal, transaminasas 20 veces sobre el valor normal y bilirrubinemia aumentada. **¿Cuál es el diagnóstico probable?**

A Coledocolitiasis
B Hepatitis A
C Hepatitis C
D Hepatitis por fármacos
E Hepatitis autoinmune

Respuesta B. Pródromo febril seguido de ictericia, transaminasas muy elevadas (patrón hepatocelular) y exposición en un campamento un mes antes (incubación de 2 a 6 semanas, transmisión fecal-oral) orientan a hepatitis A. Los 3 g de paracetamol repartidos en 5 días no alcanzan dosis hepatotóxica; el prurito refleja un componente colestásico frecuente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 128

Una niña de 8 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y aparición de ictericia asociado a orinas oscuras que se identifica como coluria. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran GOT 1.525UI/L, GPT 1.216 UI/L, bilirrubina total 11,3mg/dL de predominio directo e IgM para VHA (+). Se indica reposo por 10 días evolucionando favorablemente, sin embargo, 10 días después reaparece la ictericia, agregándose pruri- to y astenia. Se controlan pruebas hepáticas que muestran protrombinemia: 90%, GOT: 1.025 UI/L y GPT: 968 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Hepatitis crónica
B Remisión completa
C Portación asintomática del virus
D Remisión parcial con recurrencias
E Falla hepática

Respuesta D. Diagnóstico: Remisión parcial con recurrencias (opción D). Es una hepatitis A recurrente (una de las forma de presentación de la hepatitis A). Clase sobre el enfoque global de la ictericia.

▶ VER CLASE 2.01.1.011 Infecciones de piel y partes blandas

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.1 · Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Impétigo: costras melicéricas (S. aureus, S. pyogenes) o ampollas (S. aureus). Localizado: mupirocina o ácido fusídico tópico 5-7 días; extenso: cefadroxilo oral.
- Celulitis: placa eritematosa, caliente, de bordes difusos; erisipela con bordes netos y solevantados (S. pyogenes). Cefadroxilo 50 mg/kg/día o flucloxacilina/cloxacilina por 7-10 días.
- Foliculitis, forúnculos y abscesos: calor local; absceso requiere drenaje, antibiótico si celulitis asociada, fiebre o localización facial.
- Hospitalizar con antibiótico EV (cefazolina o cloxacilina) si compromiso sistémico, celulitis facial extensa, lactante pequeño o falta de respuesta en 48-72 h.
- Banderas rojas de fascitis necrotizante: dolor desproporcionado, crepitación, bulas hemorrágicas, toxicidad (riesgo mayor tras varicela): urgencia quirúrgica.
- Seguimiento: control a las 48-72 h para evaluar respuesta; impétigo recurrente: buscar portación nasal de S. aureus y descolonizar.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 26

Un niño de 3 años presenta lesiones pruriginosas en la nariz y la cara de 3 días de evolución. Al examen físico se aprecian erosiones con costras amarillentas de aspecto melicérico sobre base eritematosa, en región perinasal y peribucal. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Curaciones con suero fisiológico
B Curaciones con povidona yodada
C Aciclovir oral por 5 días
D Prednisona oral por 7 días
E Flucloxacilina por 7 días

Respuesta E. Costras melicéricas periorificiales en un preescolar corresponden a impétigo, causado por S. aureus y S. pyogenes. Se trata con antibiótico antiestafilocócico: tópico (mupirocina) si es muy localizado, u oral (flucloxacilina, cloxacilina o cefadroxilo) por 7 a 10 días. Las curaciones solas no erradican la infección y los corticoides la empeoran.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 153

Un lactante de 3 meses presenta aparición de lesiones en el abdomen y muslo, que se muestran a continuación: Foto 16 (https://accesspediatrics.mhmedical.com/content.aspx?bookid=447&sectionid=40442582). ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A Virus herpes simplex
B Streptococcus pyogenes
C Virus varicela zóster
D Virus pox
E Staphilococcus aureus

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Staphilococcus aureus). Es un impétigo buloso, causado por S. aureus. El SBOR secundario agrupa las causas no virales que pueden producir un síndrome bronquial obstructivo recurrente en lactantes y niños.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 90

Un paciente de 8 años presenta aparición de lesiones en la cara, desde hace 3 días, las que han aumentado. Al examen físico se aprecia lo siguiente: El diagnóstico más probable es:

A Acné
B Rosácea
C Erisipela
D Impétigo
E Antrax

Respuesta D. Diagnóstico: Impétigo (opción D). Se ve en la foto: Las costras melicéricas. El SBOR secundario agrupa las causas no virales que pueden producir un síndrome bronquial obstructivo recurrente en lactantes y niños.

▶ VER CLASE 2.01.1.012 Infecciones por HIV

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.1 · Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- VIH pediátrico: casi siempre transmisión vertical (embarazo, parto, lactancia). Sospechar si infecciones recurrentes o graves, candidiasis oral persistente, retraso del crecimiento, parotiditis crónica, adenopatías y hepatoesplenomegalia.
- Diagnóstico en <18 meses: PCR-ADN/carga viral (los anticuerpos maternos persisten); en >18 meses ELISA confirmado en ISP.
- Prevención de la transmisión vertical (GES): tamizaje en embarazo, TARV materna, zidovudina intraparto, cesárea si carga viral detectable, profilaxis al RN y suspensión de lactancia materna.
- Tratamiento inicial: notificar, apoyo nutricional, profilaxis con cotrimoxazol según CD4/edad; no usar vacunas vivas (BCG) en inmunosupresión grave.
- Derivar a centro de atención VIH pediátrico para TARV (GES) y seguimiento con carga viral y CD4.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer con infección por VIH, con carga viral detectable al término del embarazo, tiene un parto por cesárea. El recién nacido de término está en buenas condiciones. **Respecto de la alimentación del recién nacido, ¿cuál es la indicación correcta?**

A Lactancia materna exclusiva, porque los anticuerpos maternos protegen al niño
B Suspender la lactancia materna y alimentar con fórmula láctea
C Lactancia materna solo si la madre recibe terapia antirretroviral
D Lactancia mixta durante los primeros 6 meses
E Extraer y pasteurizar la leche en el hogar

Respuesta B. En Chile, la prevención de la transmisión vertical del VIH incluye terapia antirretroviral materna, cesárea según carga viral, profilaxis antirretroviral al recién nacido y suspensión de la lactancia materna, que se reemplaza por fórmula láctea entregada por el programa. La leche materna transmite el virus, por lo que la lactancia está contraindicada.

▶ VER CLASE 2.01.1.013 Infecciones por Salmonella

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 4.5 · Bacteriosis Zoonóticas: Brucelosis, Leptospirosis y Fiebre Tifoidea

QUÉ HAY QUE SABER

- Salmonella no tífica: gastroenteritis con fiebre, diarrea (puede ser disentérica), dolor abdominal; asociada a huevos, aves y reptiles; autolimitada.
- Fiebre tifoidea (S. Typhi): fiebre prolongada escalonada, cefalea, dolor abdominal, hepatoesplenomegalia, bradicardia relativa, roséola; leucopenia. Diagnóstico con hemocultivo (1ª semana), luego coprocultivo.
- Gastroenteritis por Salmonella no tífica: solo hidratación; antibióticos prolongan portación y se reservan para <3 meses, inmunodeprimidos, hemoglobinopatías o bacteriemia.
- Fiebre tifoidea: ceftriaxona 50-100 mg/kg/día EV o azitromicina; ciprofloxacino en adolescentes según susceptibilidad, 7-14 días.
- Complicaciones: perforación y hemorragia intestinal (3ª semana), osteomielitis por Salmonella en drepanocitosis, portación crónica vesicular.
- Notificación obligatoria de fiebre tifoidea; seguimiento con coprocultivos de control en manipuladores de alimentos y control clínico hasta la resolución.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 23

Niño con fiebre de 10 días de evolución, cefalea, mialgias, diarrea y luego deposiciones duras. Al examen físico se palpan el hígado y el bazo. **¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar el estudio?**

A Coproparasitológico seriado
B Coprocultivo
C Serología para virus Epstein-Barr
D Hemocultivo
E Prueba de Widal

Respuesta D. Fiebre prolongada, cefalea, alteración del tránsito intestinal y hepatoesplenomegalia sugieren fiebre tifoidea (Salmonella Typhi). En la primera y segunda semana el examen de mayor rendimiento es el hemocultivo; el mielocultivo es el más sensible. El coprocultivo se positiviza más tarde y la reacción de Widal tiene baja sensibilidad y especificidad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 137

Pediátrico, 2 días de dolor abdominal, diarrea líquida 10-15 episodios/día, 3 máculas que blanquean a la presión en abdomen, hepatomegalia, hemograma con Eosinofilos en 0, Anemia, coprocultivo negativo.

A Salmonella tiphy
B Campylobacter
C Salmonella enteritidi
D Shigella
E E. Coli entero hemorrágica

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Salmonella tiphy).

▶ VER CLASE 2.01.1.014 Infecciones recurrentes

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.25 · Inmunodeficiencias Primarias, Infecciones Recurrentes, Hepatomegalia e Interpretación del Hemograma Pediátrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Infecciones recurrentes: considerar normal hasta 6-8 IRA altas virales/año en lactantes que asisten a sala cuna; sospechar inmunodeficiencia si son graves, de localización inusual o por gérmenes oportunistas.
- Signos de alarma (Jeffrey Modell): ≥8 otitis/año, ≥2 sinusitis graves/año, ≥2 neumonías/año, ≥2 meses de antibióticos sin mejoría, abscesos profundos recurrentes, candidiasis persistente >1 año, necesidad de antibióticos EV, historia familiar.
- Descartar causas no inmunológicas: asma, rinitis alérgica, ERGE, hipertrofia adenoidea, tabaquismo pasivo, FQ, cardiopatía, cuerpo extraño, sala cuna.
- Estudio inicial: hemograma con recuento absoluto de linfocitos y neutrófilos, inmunoglobulinas IgG, IgA, IgM, IgE y VIH.
- Neumonías recurrentes en el mismo lóbulo sugieren causa anatómica (cuerpo extraño, malformación); en distintos lóbulos, trastorno sistémico (FQ, aspiración, inmunodeficiencia).
- Seguimiento: derivar a inmunología pediátrica si hay signos de alarma o estudio alterado; no vacunas vivas si se sospecha inmunodeficiencia celular.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 2 años asiste a sala cuna desde los 12 meses. En el último año ha tenido 8 resfríos, 2 otitis medias agudas y 1 episodio de gastroenteritis, todos de evolución favorable y manejo ambulatorio. Su peso y talla progresan en percentil 50 y el examen físico es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar inmunoglobulinas séricas
B Solicitar test de VIH y subpoblaciones linfocitarias
C Tranquilizar a los padres: es un patrón esperable para su edad
D Indicar profilaxis antibiótica
E Derivar a inmunología

Respuesta C. Los niños que asisten a sala cuna pueden tener 6 a 10 infecciones respiratorias virales al año. Infecciones leves, de buena evolución, con crecimiento normal, no sugieren inmunodeficiencia. Las señales de alarma son infecciones graves, por gérmenes oportunistas, 2 o más neumonías al año, necesidad de antibióticos endovenosos, falla de crecimiento o antecedentes familiares.

▶ VER CLASE 2.01.1.015 Meningoencefalitis/ Meningitis bacteriana aguda

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.3 · Encefalitis Aguda por VHS y Absceso Cerebral

QUÉ HAY QUE SABER

- Meningitis bacteriana: fiebre, cefalea, vómitos, compromiso de conciencia, rigidez de nuca, Kernig/Brudzinski; lactante: irritabilidad, rechazo alimentario, fontanela abombada, convulsiones.
- Agentes: RN estreptococo grupo B, E. coli, Listeria; >3 meses neumococo y meningococo (Hib raro por vacuna).
- Confirmar con punción lumbar: LCR turbio, >1.000 cél/mm³ con predominio PMN, glucosa baja (<40 o <0,4 de la glicemia), proteínas elevadas; Gram, cultivo y PCR. TC previa solo si focalidad, papiledema o shock.

- Si la PL se retrasa, no postergar antibiótico: hemocultivos y ceftriaxona 100 mg/kg/día EV (+ vancomicina 60 mg/kg/día por neumococo resistente); RN ampicilina + cefotaxima.
- Dexametasona 0,15 mg/kg c/6 h por 2-4 días, antes o con la primera dosis de antibiótico en >6 semanas (reduce hipoacusia por Hib/neumococo). Notificación inmediata y quimioprofilaxis a contactos en meningococo.
- Seguimiento: derivar/hospitalizar en UCI pediátrica; potenciales evocados auditivos al alta por riesgo de hipoacusia.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 157

Un niño de 8 años presenta un cuadro de cefalea y fiebre de 2 días de evolución, a lo que se agrega una conducta agresiva y luego desorientación. Convulsiona en varias oportunidades. Su TAC descarta hipertensión endocraneana, por lo que se realiza punción lumbar que da salida a líquido cefalorraquídeo con 100 glóbulos rojos por mm3, 20 glóbulos blancos por mm3, con 90% de mononucleares, proteínas: 80 mg/dl y glucosa: 60 mg/dl. **¿Cuál es el tratamiento inicial?**

A Oseltamivir
B Vancomicina
C Ceftriaxona
D Aciclovir
E Ampicilina

Respuesta D. Conducta alterada, desorientación y convulsiones con LCR viral hemorrágico: encefalitis herpética. Se trata con aciclovir EV.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 22

Niño de 4 años, con antecedente de una convulsión febril hace 2 años, presenta fiebre y cefalea, seguidas de deterioro del estado general y compromiso de conciencia, y luego una convulsión. La punción lumbar muestra 300 glóbulos blancos por milímetro cúbico, 80% mononucleares, y 60 glóbulos rojos crenados. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Encefalitis herpética
B Hemorragia subaracnoidea
C Meningitis bacteriana
D Meningitis tuberculosa
E Convulsión febril benigna

Respuesta A. El compromiso de conciencia persistente y el líquido cefalorraquídeo hemorrágico con pleocitosis mononuclear no corresponden a una convulsión febril simple: orientan a una encefalitis herpética, que suele afectar los lóbulos temporales.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 157

Un niño de 8 años presenta cefalea y fiebre de 2 días de evolución, a lo que se agrega conducta agresiva y luego desorientación. Convulsiona en varias oportunidades. Su TAC descarta hipertensión endocraneana, por lo que se realiza punción lumbar: LCR con 100 glóbulos rojos/mm3, 20 glóbulos blancos/mm3 (90% mononucleares), proteínas 80 mg/dL y glucosa 60 mg/dL. **¿Cuál es el tratamiento inicial?**

A Oseltamivir
B Vancomicina
C Ceftriaxona
D Aciclovir
E Ampicilina

Respuesta D. Fiebre con alteración conductual, desorientación y convulsiones (compromiso del parénquima) más LCR con pleocitosis mononuclear, glucosa normal, proteínas elevadas y eritrocitos sugieren meningoencefalitis herpética. Debe iniciarse aciclovir endovenoso de inmediato, sin esperar la PCR para virus herpes simple, porque reduce marcadamente la mortalidad y las secuelas.

▶ VER CLASE 2.01.1.016 Mononucleosis infecciosa

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.2 · Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH

QUÉ HAY QUE SABER

- Mononucleosis (VEB): adolescente con fiebre, faringoamigdalitis exudativa, adenopatías cervicales posteriores, esplenomegalia, edema palpebral y astenia marcada.
- Hemograma: linfocitosis >50% con >10% de linfocitos atípicos; transaminasas elevadas frecuentes.
- Confirmación: anticuerpos heterófilos (falsos negativos en <4 años) o IgM anti-cápside viral (VCA) para VEB.
- Tratamiento sintomático: paracetamol/AINE, hidratación, reposo; corticoides solo si obstrucción de vía aérea, anemia hemolítica o trombocitopenia grave. Amoxicilina produce exantema.
- Evitar deportes de contacto 3-4 semanas por riesgo de rotura esplénica; dolor abdominal izquierdo súbito es urgencia.
- Seguimiento: control clínico hasta resolución; la fatiga puede durar semanas. Diferencial: CMV, toxoplasmosis, VIH agudo, leucemia.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 122

Un niño de 3 años, con un cuadro de fiebre alta, asociada a malestar general y odinofagia intensa. Se inició tratamiento con amoxicilina, pero a las 48 horas presenta un exantema, que se muestra más abajo. Al examen físico, se aprecia decaído, con adenopatías cervicales anteriores dolorosas y amígdalas edematosas y eritematosas, con exudado blanco en su superficie. El exantema se muestra a continuación: **El diagnóstico más probable es:**

A Escarlatina
B Mononucleosis infecciosa
C Alergia a la penicilina
D Enfermedad de Kawasaki
E Sarampión

Respuesta B. Síndrome mononucleósico (fiebre, odinofagia, adenopatías, exudado amigdalino blanco) más exantema morbiliforme tras iniciar amoxicilina: mononucleosis infecciosa. No es una alergia verdadera a la penicilina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 129

Un niño de 7 años de edad presenta un cuadro de fiebre y odinofagia, asociado a malestar general. Al examen físico presenta faringe congestiva, con exudado amigdalino bilateral y se palpa adenopatía cervical, por lo que se inicia amoxicilina oral. Dos días después evoluciona con un exantema, que se muestra en la FOTO. El diagnóstico más probable es: NOTA: la foto original era de un niño, pero el exantema es muy similar a este (fue la foto más parecida que hallé en Google)

A Escarlatina
B Reacción alérgica a la amoxicilina
C Eritema multiforme menor
D Artritris reumatoide juvenil
E Mononucleosis infecciosa

Respuesta E. Diagnóstico: Mononucleosis infecciosa (opción E). Tiene la clínica de mononucleosis clásica. El rash post-ampicilina es clásico también.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 86

Un niño de 11 años presenta fiebre de 10 días de evolución, asociado a astenia, cefalea, malestar general y odinofagia. Al examen físico tiene FC: 90x', T°: 37,9°C, faringe congestiva y se palpan adenopatías cervicales anteriores múltiples de 0,5 cm. En el examen abdominal, tanto el hígado como el bazo se palpan 2 cm por debajo del reborde costal. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A Coprocultivo
B Hemocultivos
C Serología para Brucella
D IgM para virus hepatitis A
E Anticuerpos heterófilos

Respuesta A. Diagnóstico: Coprocultivo (opción A).

▶ VER CLASE 2.01.1.017 **Síndrome febril agudo sin foco** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.9 · Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Fiebre sin foco: fiebre ≥38 °C de <7 días sin foco tras anamnesis y examen; el riesgo de infección bacteriana grave depende de la edad.
- <28 días: hospitalizar siempre, hemograma, PCR, hemocultivos, orina por sondeo con urocultivo y punción lumbar; ampicilina + cefotaxima (no ceftriaxona en RN).
- 29-90 días: criterios de Rochester (buen aspecto, previamente sano, sin foco, GB 5.000-15.000, baciliformes <1.500, orina ≤10 GB/campo). Todos presentes: bajo riesgo, ambulatorio con control en 24 h; falla uno: hospitalizar.
- 3-36 meses con buen estado: buscar ITU (causa oculta más frecuente) con orina completa y urocultivo por sondeo; si fiebre >39 °C sin vacunas completas considerar hemograma y PCR.
- Antipirético: paracetamol 10-15 mg/kg/dosis c/6 h; ibuprofeno 5-10 mg/kg c/8 h solo >6 meses. Mal aspecto a cualquier edad: hospitalizar y tratar.
- Seguimiento: control en 24-48 h y reconsulta si fiebre >5 días, decaimiento, petequias o rechazo alimentario.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 50 días de vida, con fiebre de 38,6 °C constatada en el hogar. Al examen se ve alerta, reactivo y sin foco infeccioso. El hemograma muestra 17.200 leucocitos/mm³ con 12% de baciliformes. El sedimento de orina es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Manejo ambulatorio con paracetamol y control en 24 horas

B Hospitalizar, completar el estudio e iniciar antibióticos empíricos

C Dar de alta porque el examen físico y la orina son normales

D Iniciar amoxicilina oral ambulatoria y repetir el hemograma en 48 horas

E Solicitar solo una radiografía de tórax antes de decidir

Respuesta B. El paciente tiene 50 días, el rango de Rochester, pero falla el criterio de laboratorio (leucocitos y baciliformes elevados), aunque el examen físico y la orina sean normales. Un solo criterio alterado saca al paciente del grupo de bajo riesgo: se hospitaliza, se completa el estudio (incluida la punción lumbar) y se inician antibióticos empíricos.

▶ VER CLASE 2.01.1.018 Síndrome febril prolongado

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.2 · Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH

QUÉ HAY QUE SABER

- Fiebre prolongada: fiebre >38 °C por más de 7-10 días (pediatría) sin causa aparente tras evaluación inicial.
- Causas: infecciosas las más frecuentes (VEB, CMV, Bartonella, ITU, TBC, osteomielitis, abscesos), luego reumatológicas (AIJ sistémica, LES, Kawasaki) y neoplásicas (leucemia, linfoma).
- Estudio inicial: hemograma con frotis, VHS, PCR, orina completa y urocultivo, hemocultivos, transaminasas, Rx tórax, serologías (VEB, CMV, Bartonella), PPD/IGRA.
- No dar antibióticos empíricos en niño estable sin diagnóstico: enmascaran la causa.
- Banderas rojas: baja de peso, sudoración nocturna, dolor óseo, citopenias, hepatoesplenomegalia, adenopatías duras: derivar con urgencia a hematooncología.
- Seguimiento: hospitalizar o derivar a infectología/reumatología pediátrica para estudio dirigido; registrar curva febril.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 153

Un niño de 5 años presenta fiebre desde hace 7 días, que ha respondido parcialmente al uso de antipiréticos. Al examen físico se palpa una adenopatía cervical de 1,5 cm y en el examen abdominal se palpa esplenomegalia. Se solicita ecografía abdominal, que muestra múltiples lesiones hipoecogénicas de pequeño tamaño en hígado y bazo, compatibles con microabscesos, sin pared visible. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Citomegalovirus

B Virus de Epstein-Barr

C Bartonella henselae

D Echinococcus granulosus

E Mycobacterium tuberculosis

Respuesta C. Fiebre prolongada con adenopatía regional y lesiones hipoecogénicas hepatoesplénicas (microabscesos o granulomas) es la forma hepatoesplénica de la enfermedad por arañazo de gato, causada por Bartonella henselae; es una causa importante de síndrome febril prolongado en niños. Se confirma con serología IgM/IgG. Epstein-Barr y citomegalovirus dan esplenomegalia difusa, no lesiones focales.

▶ VER CLASE 2.01.1.019 Asma bronquial

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 1.3 · Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Asma: sibilancias, tos nocturna o con ejercicio, disnea recurrente reversible, atopía personal/familiar. En >5-6 años confirmar con espirometría: obstrucción reversible con aumento VEF1 ≥12% post broncodilatador.
- Clasificar control (GINA): síntomas diurnos, despertares nocturnos, uso de rescate >2 veces/semana, limitación de actividad. Asma en <15 años es GES.
- Tratamiento de mantención: corticoide inhalado en dosis baja (budesonida 200 µg/día o fluticasona 100 µg/día) con aerocámara; escalar a dosis media o agregar LABA (>6 años) o montelukast.
- Rescate: salbutamol 2-4 puff (100 µg/puff) con aerocámara c/20 min por 3 veces en crisis; crisis moderada-grave: prednisona 1-2 mg/kg/día por 3-5 días.
- Educación: técnica inhalatoria, plan de acción escrito, evitar tabaco y alérgenos, vacuna influenza anual.
- Seguimiento: control cada 3 meses en APS (programa IRA); ajustar escalón según control; derivar si asma grave o mal controlada pese a tratamiento adecuado.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 8 años con asma usa salbutamol inhalado a demanda. En el último mes ha tenido síntomas diurnos 4 días por semana, despertares nocturnos por tos 2 veces por semana y limitación para hacer deporte. Su técnica inhalatoria con aerocámara es correcta. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener salbutamol a demanda

B Iniciar corticoide inhalado en dosis baja de mantención

C Iniciar prednisona oral por 5 días

D Iniciar montelukast como monoterapia de primera línea

E Iniciar teofilina oral

Respuesta B. Un asma no controlada (síntomas más de 2 veces por semana, despertares nocturnos, limitación de actividad) requiere tratamiento de mantención. De acuerdo con la guía GES de asma en menores de 15 años y GINA, el pilar es el corticoide inhalado en dosis baja (ej. budesonida o fluticasona) con aerocámara, más salbutamol de rescate.

▶ VER CLASE 2.01.1.020 Bronquiolitis

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.5 · Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Bronquiolitis: primer episodio de obstrucción bronquial en <1-2 años tras pródromo catarral; VRS el principal agente (invierno). Taquipnea, retracción, sibilancias y crépitos difusos.
- Diagnóstico clínico; Rx de tórax solo si duda o gravedad (hiperinsuflación, atelectasias). Panel viral para cohortear en hospitalizados.
- Tratamiento de soporte: aseo nasal, fraccionar alimentación, O2 si saturación <93%; hidratación. Sin evidencia para broncodilatadores, corticoides ni antibióticos de rutina.
- Factores de riesgo de gravedad: <3 meses, prematurez, cardiopatía congénita, displasia broncopulmonar, inmunodeficiencia. Apneas en RN y prematuros.
- Hospitalizar si saturación <93% con aire ambiente, apneas, dificultad respiratoria importante, rechazo alimentario o deshidratación.
- Prevención: nirsevimab al RN y lactantes en su primera temporada de VRS (campaña MINSAL). Seguimiento: control en 24-48 h en APS con score de Tal.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 72

Un lactante de 5 meses presenta un cuadro de tos y coriza, asociado a fiebre hasta 38,5°C. Al día siguiente evoluciona con dificultad respiratoria, taquipnea, retracción subcostal. Al examen físico tiene FR 70x', uso de musculatura accesoria, sibilancias inspiratorias y espiratorias difusas e intensas, más cianosis perioral. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Virus respiratorio sincicial

B Bordetella pertussis

C Virus influenza

D Virus parainfluenza

E Neumococo

Respuesta A. Bronquiolitis clásica del lactante, cuyo agente etiológico principal es el virus respiratorio sincicial.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 158

Un lactante de 8 meses presenta fiebre y rinorrea de 48 horas de evolución, con dificultad respiratoria en las últimas horas. Al examen físico presenta retracción subcostal e intercostal moderada, FC 120x', FR 35x', saturación de oxígeno del 93%. En el examen pulmonar se auscultan sibilancias y crépitos bilaterales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Bronquiolitis

B Asma del lactante

C Neumonía multifocal

D Neumonía atípica

E Cardiopatía congénita

Respuesta A. Cuadro catarral seguido de dificultad respiratoria con sibilancias en un lactante: caso clásico de bronquiolitis, definida como el primer episodio de síndrome bronquial obstructivo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 148

Un lactante de 5 meses de edad es llevado a urgencias, por presentar un cuadro de obstrucción bronquial. Al examen físico presenta taquipnea importante, satura 90%, tiene retracción intercostal, cianosis perioral y sibilancias bilaterales intensas. **¿Cuál es la primera medida que se debe tomar?**

A Nebulizaciones con salbutamol
B Nebulizaciones con budesonida
C Dar corticoides orales
D Dar oxígeno por mascarilla
E Administrar corticoides endovenosos

Respuesta D. Ante hipoxemia en un lactante grave, la medida más urgente es corregir la oxigenación; el oxígeno es la intervención con mayor evidencia de beneficio en la bronquiolitis, más que broncodilatadores o corticoides.

▶ VER CLASE 2.01.1.021 Enfermedad pulmonar crónica

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.18 · Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM

QUÉ HAY QUE SABER

- Enfermedad pulmonar crónica pediátrica: síntomas respiratorios persistentes >3 meses o recurrentes (tos húmeda crónica, sibilancias, neumonías a repetición) con compromiso del crecimiento.
- Causas: displasia broncopulmonar (prematuro con O2 a las 36 semanas corregidas), fibrosis quística, bronquiectasias, aspiración crónica, discinesia ciliar, bronquiolitis obliterante post adenovirus.
- Sospechar: hipocratismo digital, deformidad torácica, crépitos persistentes, desnutrición, hipoxemia crónica.
- Estudio inicial: Rx de tórax, saturometría, test del sudor, evaluación nutricional; TC de tórax por especialista.
- Manejo inicial: oxigenoterapia si saturación <93%, kinesioterapia respiratoria, apoyo nutricional, vacunas al día (influenza, neumococo) y nirsevimab/palivizumab en displásicos.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar infantil; programa de oxígeno domiciliario (POD) cuando corresponde.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un recién nacido de 26 semanas de edad gestacional y 850 g recibió surfactante y ventilación mecánica por enfermedad de membrana hialina. Al llegar a las 36 semanas de edad gestacional corregida aún requiere oxígeno suplementario para mantener saturaciones adecuadas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Taquipnea transitoria del recién nacido
B Síndrome de aspiración meconial
C Displasia broncopulmonar
D Hipertensión pulmonar persistente aislada
E Fibrosis quística

Respuesta C. La displasia broncopulmonar es la enfermedad pulmonar crónica del prematuro: requerimiento de oxígeno a las 36 semanas de edad corregida en un prematuro menor de 32 semanas, tras ventilación mecánica u oxígeno. Se asocia a prematurez extrema, barotrauma, toxicidad por oxígeno e infección.

▶ VER CLASE 2.01.1.022 Estridor

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.6 · Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona

QUÉ HAY QUE SABER

- Estridor: ruido inspiratorio por obstrucción de vía aérea extratorácica (laringe, tráquea alta); bifásico si es subglótico o traqueal.
- Agudo con fiebre y tos perruna: laringitis (lo más frecuente). Agudo sin fiebre y súbito: cuerpo extraño. Toxicidad, babeo, posición trípode: epiglotitis o traqueítis bacteriana.
- Crónico desde el nacimiento: laringomalacia (lo más frecuente, aumenta en decúbito supino y con llanto, mejora al año), parálisis de cuerdas vocales, estenosis subglótica, hemangioma subglótico.
- Tratamiento: laringitis con dexametasona 0,15-0,6 mg/kg VO/IM y nebulización con adrenalina si estridor en reposo; sospecha de epiglotitis: no examinar faringe, O2, vía aérea por experto y ceftriaxona.
- Signos de gravedad: estridor en reposo, retracción, cianosis, compromiso de conciencia, saturación baja.
- Seguimiento: derivar a otorrinolaringología/broncopulmonar para nasofibroscopía si estridor persistente, recurrente o con mal incremento ponderal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 2 meses, traído porque desde las 2 semanas de vida tiene un ruido inspiratorio agudo que aumenta con el llanto, al alimentarse y en decúbito supino, y disminuye en decúbito prono. Afebril, sin coriza, sin tos ni disfonía. Buen incremento de peso y saturación de 98%. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Laringomalacia congénita
B Laringitis aguda obstructiva
C Cuerpo extraño en la vía aérea
D Epiglotitis
E Absceso retrofaríngeo

Respuesta A. Estridor inspiratorio desde las primeras semanas, que empeora con el llanto, la alimentación y el decúbito supino, sin fiebre ni cuadro catarral y con buen crecimiento, es típico de laringomalacia: la causa más frecuente de estridor crónico del lactante, benigna y que suele resolverse sola.

▶ VER CLASE 2.01.1.023 Faringoamigdalitis

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.13 · Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

QUÉ HAY QUE SABER

- Faringoamigdalitis estreptocócica: 5-15 años, fiebre, odinofagia, exudado, adenopatías cervicales anteriores dolorosas, petequias en paladar, sin tos ni coriza.
- <3 años y presencia de tos, rinorrea, conjuntivitis o aftas: etiología viral (adenovirus, coxsackie/herpangina, VEB).
- Test rápido o cultivo faríngeo si hay dudas; criterios de Centor/McIsaac orientan.
- Tratamiento: penicilina benzatina 600.000 UI IM (<27 kg) o 1.200.000 UI (≥27 kg) dosis única, o amoxicilina 50 mg/kg/día por 10 días; alergia: azitromicina 12 mg/kg/día por 5 días.
- Complicaciones: absceso periamigdalino, fiebre reumática, glomerulonefritis postestreptocócica, PANDAS.
- Seguimiento: no requiere control si buena evolución; reconsultar si fiebre >48 h con tratamiento, trismus o dificultad para tragar.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 75

Un niño de 2 años y 6 meses presenta fiebre, hasta 39°C, asociado a irritabilidad, odinofagia y malestar general. En su examen físico destacan adenopatías cervicales bilaterales y faringe eritematosa y congestiva, con abundante exudado amigdalino bilateral. La auscultación pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Amigdalitis estreptocócica
B Mononucleosis infecciosa
C Influenza
D Infección por Streptococcus pneumoniae
E Infección por adenovirus

Respuesta E. En un niño menor de 3 años la causa más probable de una faringitis con exudado es viral, por adenovirus. La faringitis estreptocócica es extraordinariamente rara a esa edad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 131

Un paciente de 8 años presenta un cuadro de odinofagia de un día de evolución, intenso, asociado a fiebre. Al examen físico tiene faringe congestiva, con exudado amigdalino bilateral y presencia de una adenopatía cervical. Su hermano menor está en tratamiento por escarlatina confirmada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar amoxicilina oral
B Solicitar test pack para estreptococo
C Solicitar cultivo faríngeo
D Solicitar IgM para virus Ebstein Baar
E Indicar tratamiento sintomatico

Respuesta A. Niño en edad escolar con fiebre, exudado y adenopatía, y contacto familiar con escarlatina confirmada: la probabilidad de estreptococo es alta y se inicia amoxicilina empírica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 143

Un paciente de 8 años consulta por fiebre alta, asociada a odinofagia intensa. En su examen físico se aprecia faringe eritematosa, asociada a exudado bilateral. Se solicita una prueba rápida de detección de antígenos estreptocócicos, la que resulta positiva. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Amoxicilina
B Amoxicilina + ácido clavulánico
C Azitromicina
D Clindamicina
E Metronidazol

Respuesta A. Test rápido positivo para estreptococo del grupo A: el tratamiento de elección es amoxicilina por 10 días. El estreptococo es 100% sensible a la penicilina, por lo que no se necesita clavulánico ni macrólidos, que quedan para la alergia a penicilina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 110

Un niño de 18 meses presenta dolor de garganta y fiebre de 2 días de evolución de hasta 39,0°C, asociado a irritabilidad, malestar general y secreción conjuntival bilateral. Al examen físico, además, se observa faringe eritematosa exudado amigdalino bilateral y se palpan adenopatías cervicales anteriores. El agente etiológico más probable es:

A Staphilococcus aureus
B Streptococcus pyogenes
C Metaneumovirus
D Adenovirus
E Virus de Ebstein Baar

Respuesta D. La clásica amigdalitis exudativa en el menor de 3 años es por ADV. Suele tener fiebre alta y, en este caso, además, viene con la clásica fiebre faringoconjuntival por ADV. Si no hubiese tenido afectación ocular igual sería por ADV, así que a aprender este caso clínico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 107

Un niño de 8 años presenta odinofagia intensa, de dos días de evolución, con escasa congestión nasal. Al examen físico se observan amígdalas edematosas y aumentadas de volumen, con exudado blanquecino en los surcos, adenopatías cervicales dolorosas y fiebre: 39°C. La conducta más adecuada es:

A Iniciar amoxicilina
B Solicitar TAC de cuello
C Iniciar cetriaxona
D Iniciar tratamiento sintomático
E Solicitar prueba rápida de detección de Streptococcus pyogenes

Respuesta A. Orienta a etiología bacteriana: 1. el dolor intenso, 2. el exudado característico, 3. las adenopatías, 4. la fiebre alta, 5. la edad (3 a 15 años) y la ausencia de sintomatología catarral. La congestión nasal suele orientar más a etiología viral, pero se describe como "escasa". Con ello, cumple 4 o 5 criterios para iniciar antibióticos (amoxicilina de elección). Con 0 o 1, se asume viral; con 2 o 3 se pide cultivo o test rápido; con 4+ se trata como bacteriana.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 107

Un niño de 2 años consulta por odinofagia de 2 días de evolución, asociada a fiebre de 38,1 °C. En su examen físico presenta amígdalas eritematosas y aumentadas de tamaño, con exudado bilateral de aspecto purulento, y se palpan adenopa`as cervicales pequeñas bilaterales. Su examen cardiopulmonar es normal. Se solicita prueba de detección de estreptococo beta hemolítico del grupo A, que resulta positiva. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A Azitromicina
B Amoxicilina
C Claritromicina
D Amoxicilina + ácido clavulánico
E Penicilina sódica

Respuesta B. Si bien es rara la amigdalitis bacteriana en menores de 3 años, en este caso Gene 3 criterios de Centor (fiebre, exudado y adenopatías), por lo que es correcto haberle pedido las pruebas de detección de SGA. Al estar positivas, se obliga al tratamiento antibiótico. De elección se usa la amoxicilina sola. El SGA no desarrolla betalactamasas, por lo que no es necesario el ácido clavulánico. La penicilina benzatina en una dosis es una buena opción, aunque dolorosa, en cambio la penicilina sódica...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 144

Un lactante de 10 meses, presenta fiebre de 4 días de evolución, de hasta 39,1°C, asociado a irritabilidad y malestar general. Al examen físico tiene secreción conjuntival bilateral, adenopatías cervicales anteriores y amígdalas con exudado blanquecino bilateral. El agente etiológico más probable es:

A Streptococcus pneumoniae
B Streptococcus pyogenes
C Staphilococcus aureus
D Adenovirus
E Citomegalovirus

Respuesta D. Es la clásica infección por ADV, en este caso con una fiebre faringoconjuntival. Es importante hacer notar que es la causa más frecuente de amigdalitis exudativa en el menor de 3 años, así que, incluso si no hubiese tenido una conjuntivitis, seguiría siendo una infección por ADV.

▶ VER CLASE `2.01.1.024` **Infecciones respiratorias agudas bajas y sus complicaciones** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.7 · Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización

QUÉ HAY QUE SABER

- IRA baja: neumonía adquirida en la comunidad (NAC) con fiebre, tos, taquipnea según edad (<2 m >60; 2-12 m >50; 1-5 años >40 rpm), retracción y crépitos.
- Agentes: virus en <2 años (VRS); neumococo la principal bacteria a toda edad; Mycoplasma y Chlamydophila en escolares (tos persistente, cefalea, infiltrado intersticial).
- Rx tórax confirma y detecta complicaciones: derrame pleural, empiema, neumonía necrotizante, absceso, neumotórax.
- NAC bacteriana ambulatoria: amoxicilina 80-100 mg/kg/día c/8-12 h por 7-10 días; atípica (>5 años): azitromicina 10 mg/kg/día por 5 días o claritromicina.

- Hospitalizar si <3 meses, saturación <93%, dificultad respiratoria grave, apneas, rechazo alimentario, complicación o mal estado general (ampicilina o ceftriaxona EV); derrame: toracocentesis y drenaje si empiema.
- Seguimiento: control a las 48-72 h en APS (programa IRA); Rx de control solo si evolución tórpida o neumonía complicada.

PREGUNTAS · 10

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 45

Un niño de 4 años presenta un cuadro de fiebre hasta 39,5°C, asociada a tos con expectoración mucopurulenta, de 2 días de evolución. Además refiere cefalea y marcado malestar general. Al examen físico está decaído, febril, con FC 100x', examen pulmonar con crepitaciones localizadas en la zona superior. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Mycoplasma pneumoniae
B Chlamydia pneumoniae
C Streptococcus pneumoniae
D Haemophilus influenzae
E Staphylococcus aureus

Respuesta C. Cuadro agudo, fiebre alta, crépitos localizados en un niño de 4 años: neumonía típica bacteriana, cuyo agente clásico es Streptococcus pneumoniae.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 15

Niña escolar con tos seca, crepitaciones bilaterales e infiltrados intersticiales en la radiografía de tórax. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Streptococcus pneumoniae
B Mycoplasma pneumoniae
C Virus sincicial respiratorio
D Haemophilus influenzae
E Chlamydia trachomatis

Respuesta B. Escolar con tos seca prolongada e infiltrado intersticial bilateral: cuadro típico de neumonía atípica, cuyo agente clásico en esta edad es Mycoplasma pneumoniae.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 9 meses, previamente sano, con 2 días de fiebre hasta 38,9°C y tos. Al examen: FR 52 rpm, saturación 96% ambiental, buen estado general, crépitos localizados en la base pulmonar derecha. Tolera bien la alimentación. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado?**

A Amoxicilina oral 80 a 90 mg/kg/día por 7 días
B Azitromicina oral por 5 días
C Ampicilina endovenosa en hospitalización
D Amoxicilina con ácido clavulánico
E Solo control ambulatorio, sin antibiótico

Respuesta A. Lactante de 9 meses con neumonía típica sin criterios de hospitalización: amoxicilina oral en dosis alta por 7 días es la primera línea.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 8

Un recién nacido de 2 meses de edad, presenta un cuadro de tos con expectoración, asociado a taquipnea. Al examen físico, tiene T°: 38,5°C, frecuencia cardíaca de 100 x' y frecuencia respiratoria de 30 por minuto, saturando 91% a FiO2 ambiental. Su examen pulmonar solo muestra crepitaciones bilaterales. Como antecedentes, nació por parto vaginal y sufrió una conjuntivitis neonatal con secreción serosa a los 15 días de vida, la que fue tratada exitosamente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Cardiopatía congénita
B Infección por estreptococo grupo B
C Fibrosis quística
D Infección por Streptoccus pneumoniae
E Infección por Chlamydia trachomatis

Respuesta B. Diagnóstico: Infección por estreptococo grupo B (opción B). Positiva (parto progresa) → continuar vía vaginal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 157

Un paciente de 7 años, con historia de 8 días de tos y coriza, sin otros síntomas, presenta desde hace 24 horas aumento de su tos asociado a expectoración mucopurulenta, dificultad respiratoria y sensación febril. Al examen físico se encuentra decaído, con temperatura de 38°C, su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente de forma bilateral, asociado a estertores y sibilancias difusas. El tratamiento de elección en este caso es:

A Claritromicina
B Amoxicilina
C Amoxicilina con ácido clavulánico
D Acetaminofeno y salbutamol
E Cefadroxilo

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Claritromicina (opción A). Es una NAC atípica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 43

Un niño de 8 años presenta, desde hace dos semanas de odinofagia, rinorrea y tos, a lo que se le ha agregado disnea progresiva y fiebre hasta 38,5°C. Hace dos días se agrega un exantema eritematoso polimorfo. Al examen físico destacan crepitaciones y sibilancias bilaterales, difusas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A Amoxicilina
B Amoxicilina más ácido clavulánico
C Claritromicina
D Oseltamivir
E Aciclovir

Respuesta C. Tiene una neumonía atípica por Mycoplasma pneumoniae. Recordar que puede hacer un exantema eritematoso o un eritema multiforme menor (más frecuentemente el EMM se produce por infección por herpes o por medicamentos).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 108

Una niña de 7 años presenta un cuadro de 4 días de evolución con fiebre alta, tos con expectoración mucopurulenta, a lo que se agregó dolor torácico con la inspiración profunda y, recientemente, también dolor abdominal y deposiciones diarreicas. Al examen físico, está febril con T°: 38,8°C, con frecuencia cardíaca: 110x' y, en su examen cardiopulmonar se ausculta murmullo pulmonar disminuido bilateralmente, abolido en la base derecha, con crépitos en esa zona. El examen abdominal muestra dolor difuso a la palpación profunda, sin signos peritoneales y se ausculta aumento de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuál de los siguientes es el examen de elección para iniciar el estudio?

A Ecografía abdominal
B Videotoracoscopía
C Radiografía de tórax lateral en decúbito lateral
D TAC de tórax
E Radiografía de tórax anteroposterior y lateral

Respuesta E. Neumonía y Dolor Abdominal: El paciente presenta un cuadro clínico de neumonía clásica. Es importante tener en cuenta que la neumonía puede manifestarse con dolor abdominal y otros síntomas abdominales. Por lo tanto, el examen inicial a realizar es una radiografía de tórax anteroposterior y lateral.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 157

Un niño de 7 años presenta rinorrea y tos de 9 días de evolución, que han aumentado y se asociaron a disnea, progresiva y fiebre hasta 38,2°C. Al examen físico presenta T°C: 37,5°C, frecuencia respiratoria de 30 por minuto, murmullo pulmonar bilateral, simétrico, algo diminuido, con sibilancias y crepitaciones bilaterales. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A Mycoplasma pneumoniae
B Streptococcus pyogenes
C Bordetella pertusis
D Virus parainfluenza
E Virus respiratorio sincicial

Respuesta A. Es una neumonía atípica, que suelen ser causadas por mycoplasma y son muy frecuentes en la edad escolar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 16

Niño de 2 meses con conjuntivitis a los 12 días, luego tos seca, crepitaciones y sibilancias. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A Streptococcus pneumoniae
B Mycoplasma pneumoniae
C Virus sincicial respiratorio
D Ureaplasma urealyticum
E Chlamydia trachomatis

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Chlamydia trachomatis). Chlamydia trachomatis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 19

Una niña de 7 años presenta un cuadro de 9 días de tos disfónica, a lo que, en los últimos días, se agrega astenia, malestar general, dificultad respiratoria y fiebre hasta 38,5°C. Al examen físico está en buenas condiciones, con frecuencia cardíaca: 90x', saturación arterial 95% y T°:38°C. Tiene faringe eritematosa, sin exudado. Al examen pulmonar, se auscultan sibilancias y crepitaciones bilaterales. Se solicita una radiografía, que muestra múltiples infiltrados pulmonares bilaterales, con atelectasias lineales en las bases. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A Adenovirus
B Virus parainfluenza
C Mycoplasma pneumoniae
D Streptococcus pneumoniae
E Bordetella pertusis

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Mycoplasma pneumoniae).

▶ VER CLASE 2.01.1.025 **Laringitis** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Otorrino 14.17 · Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia
Pediatría 18.6 · Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona

QUÉ HAY QUE SABER

- Laringitis aguda obstructiva (crup): 6 meses-3 años, parainfluenza; tos perruna, disfonía, estridor inspiratorio, inicio nocturno, fiebre baja.
- Graduación (Downes/Westley): I disfonía y estridor con llanto; II estridor en reposo y retracción; III agitación, palidez, retracción intensa; IV cianosis, compromiso de conciencia.
- Tratamiento: dexametasona 0,15-0,6 mg/kg VO o IM dosis única en todos los grados (o budesonida nebulizada 2 mg).
- Grado ≥II: nebulización con adrenalina racémica 0,05 ml/kg o adrenalina corriente 1:1.000 0,5 ml/kg (máx 5 ml); observar 2-4 h por efecto rebote.
- Hospitalizar si grado III-IV, estridor persistente en reposo tras tratamiento, <6 meses o recurrencia; diferencial con epiglotitis, cuerpo extraño y traqueítis bacteriana.
- Seguimiento: control en 24 h; laringitis recurrente o en <6 meses: derivar a otorrino para descartar anomalía de vía aérea.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 133

Un lactante de 12 meses presenta un cuadro de tos, rinorrea y fiebre hasta 38,8°C de 24 horas de evolución, a lo que hoy se agregó dificultad respiratoria. Al examen físico presenta estridor inspiratorio, que aumenta con el llanto, asociado a retracción intercostal moderada. Su saturación de oxígeno es 94% y, al examen pulmonar se ausculta murmullo pulmonar conservado bilateral con transmisión de ruidos desde la vía aérea superior. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Laringitis aguda obstructiva
B Neumonía atípica
C Neumonía bilateral
D Asma del lactante
E Neumonitis viral

Respuesta A. Es una laringitis aguda obstructiva clásica: un cuadro gripal seguido de síntomas obstructivos, con estridor laríngeo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 158

Una niña de 3 años, previamente sana, presenta un cuadro de 2 días de evolución de rinorrea, asociada a fiebre de 39°C, con tos disfónica, a la que se agrega dificultad respiratoria hace una hora. Al examen físico, su frecuencia respiratoria es 48 por minuto, se escucha estridor inspiratorio y espiratorio y se objetiva retracción subcostal y supraesternal. **La conducta inicial más adecuada es:**

A Administrar adrenalina subcutánea
B Realizar nebulizaciones con salbutamol al 0,5%
C Realizar intubación orotraqueal
D Realizar nebulizaciones con bromuro de ipatropio al 0,5%
E Realizar nebulizaciones con adrenalina racémica al 0,1%

Respuesta E. La laringitis obstructiva se trata con oxígeno, adrenalina racémica en nebulización y corticoides sistémicos, en ese orden de administración.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 14 meses llega a urgencia a las 2:00 AM con tos ronca perruna de inicio brusco y dificultad respiratoria. Tuvo congestión nasal leve 2 días. Está tranquilo en brazos de su madre, afebril. En reposo se ausculta estridor inspiratorio continuo, con retracción supraesternal e intercostal moderada. FR 38 por minuto, saturación 96% ambiental, murmullo pulmonar simétrico. Recibió dexametasona oral y adrenalina nebulizada, y a los 30 minutos está sin estridor. **¿Cuál es la conducta más adecuada ahora?**

A Alta inmediata, porque ya no tiene estridor
B Observación en urgencia por 2 a 4 horas y alta si no reaparece el estridor en reposo
C Agregar amoxicilina oral por 7 días
D Intubación orotraqueal profiláctica
E Repetir la dexametasona cada 6 horas por 3 días

Respuesta B. Es un croup grado II de Taussig. La adrenalina alivia rápido, pero su efecto dura unas 2 horas y puede haber rebote, por lo que se observa 2 a 4 horas. La dexametasona es de dosis única. No hay indicación de antibiótico en un croup viral.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 2 años, con 2 días de coriza, presenta esta noche disfonía, tos perruna y estridor inspiratorio audible en reposo. Tiraje subcostal leve. Afebril, sin sialorrea. Buen estado general entre los episodios de tos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Dexametasona oral en dosis única, con observación breve
B Solo observación, sin fármacos, porque está afebril
C Adrenalina racémica nebulizada y hospitalización directa
D Amoxicilina oral por sospecha de sobreinfección
E Intubación orotraqueal preventiva

Respuesta A. Estridor en reposo con tiraje leve corresponde a grado II moderado. La dexametasona oral está indicada en todos los grados; la adrenalina se reserva para disnea más marcada, que este caso no presenta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 139

Un niño de 18 meses presenta un cuadro de tos, rinorrea, disfonía y fiebre, hasta 38,5°C. Hace una hora presenta un cuadro de dificultad respiratoria, con respiración ruidos

A Al examen físico se aprecia niño taquipneico, con estridor inspiratorio, uso de musculatura accesoria, sin cianosis. La auscultación pulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

A Laringitis aguda viral
B Croup espasmódico
C Cuerpo extraño bronquial
D Laringomalacia

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (). Esta clase aborda la laringitis aguda y su variante obstructiva (crup viral).

▶ VER CLASE 2.01.1.026 Otitis media

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.1 · Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos

QUÉ HAY QUE SABER

- Otitis media aguda: otalgia, fiebre, irritabilidad; otoscopía con tímpano abombado, eritematoso, sin movilidad u otorrea. Agentes: neumococo, H. influenzae no tipificable, Moraxella.
- Tratamiento de elección: amoxicilina 80-90 mg/kg/día c/12 h, 10 días en <2 años y 5-7 días en ≥2 años con cuadro leve.
- Falla a 48-72 h o uso reciente de amoxicilina: amoxicilina-ácido clavulánico; alergia: macrólido o cefalosporina de 2ª generación; no tolera VO: ceftriaxona 50 mg/kg IM por 1-3 días.
- Observación sin antibiótico posible en >2 años con cuadro unilateral leve y control asegurado; analgesia con paracetamol o ibuprofeno siempre.
- Complicaciones: mastoiditis (retroauricular eritematoso, pabellón desplazado), parálisis facial, meningitis, absceso; hospitalizar y derivar.
- Seguimiento: control al terminar tratamiento; otitis media con efusión persistente >3 meses o hipoacusia: derivar a ORL.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 175

Un paciente de 3 años, sin antecedentes, con cuadro de rinofaringitis viral de dos días de evolución en tratamiento sintomático, es traído por presentar desde hace unas horas mayor compromiso del estado general, asociado a otalgia intensa izquierda y sensación febril. Al examen físico destaca examen cardiopulmonar normal y a la otoscopía se aprecia tímpano izquierdo eritematoso y abombado con escasa secreción purulenta. **El fármaco de elección en este caso es:**

A Ibuprofeno oral
B Amoxicilina oral
C Amoxicilina con ácido clavulánico oral
D Gentamicina tópica
E Claritromicina oral

Respuesta B. Es una OMA: se parte con amoxicilina sola. El ácido clavulánico se agrega solo si no responde a las 72 horas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 13

Un niño de 3 años presenta un cuadro de 5 días de evolución de rinorrea, fiebre y odinofagia, al que, hace dos días se le agrega otalgia, por lo que se realiza otoscopía que muestra tímpano abombado y eritematoso. Se inicia amoxicilina 50 mg/kg al día, sin embargo, a las 48 horas no ha mostrado ningún tipo de mejoría. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Aumentar la dosis a 100 mg/Kg al día
B Cambiar el tratamiento a azitromicina oral 10 mg/Kg al día
C Agregar ácido clavulánico al tratamiento oral
D Solicitar una TAC de peñasco
E Iniciar ceftriaxona endovenosa

Respuesta C. Sin respuesta a las 48 a 72 horas se agrega ácido clavulánico, para cubrir Haemophilus y Moraxella productores de betalactamasas. Aquí la dosis inicial fue baja, por lo que la dosis recomendada sigue siendo 80 a 90 mg/kg/día.

▶ VER CLASE 2.01.1.027 Resfrío común

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.13 · Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

QUÉ HAY QUE SABER

- Resfrío común: rinorrea, obstrucción nasal, estornudos, odinofagia leve, fiebre baja; rinovirus el principal agente. Duración 7-10 días, autolimitado.
- Rinorrea purulenta no implica infección bacteriana; no requiere antibiótico.
- Manejo: aseo nasal con suero fisiológico, hidratación, paracetamol si fiebre; elevación de la cabecera.
- No usar antitusivos, mucolíticos ni descongestionantes en <6 años (riesgo de toxicidad); no usar aspirina.
- Complicaciones a vigilar: otitis media, sinusitis (síntomas >10 días o empeoramiento tras mejoría), neumonía, crisis obstructiva.

- Seguimiento: no requiere control; reconsultar si fiebre >3 días, dificultad respiratoria, otalgia o compromiso del estado general.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 147

Un niño de 3 años presenta congestión nasal, con rinorrea serosa, asociada a tos y ligera odinofagia. Al examen físico tiene temperatura de 37,3 °C, faringe congestiva rosada y rinorrea abundante. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Solución salina intranasal
B Amoxicilina oral
C Corticoides nasales
D Diclofenaco oral
E Azitromicina oral

Respuesta A. Rinorrea serosa, tos, odinofagia leve y temperatura normal corresponden a un resfrío común viral. El manejo es sintomático: aseo nasal con solución salina, hidratación y paracetamol si hay fiebre o molestias. Los antibióticos no acortan el cuadro ni previenen complicaciones, y los AINE como el diclofenaco no se recomiendan en preescolares para este fin.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 166

Un paciente de 10 años, es traído por cuadro de 2 días de odinofagia, asociado a tos seca y rinorrea, que durante el primer día se asoció a sensación febril. Al examen físico se encuentra con temperatura de 36,8ºC, faringe eritematosa, amígdalas aumentadas de tamaño con escaso exudado blanquecino, examen cardiopulmonar normal. El diagnóstico más probable es:

A Amigdalitis pultácea
B Influenza
C Rinofaringitis aguda
D Coqueluche
E Adenovirus

Respuesta C. Tiene una infección respiratoria alta, con signos virales: tos, rinorrea. Si bien tiene exudado (orienta a adenovirus), no hay mayores indicios que sea por adenovirus (si hubiese conjuntivitis viral sí sería adenovirus). Es seguro que hay una rinofaringitis viral

▶ VER CLASE 2.01.1.028 Síndrome bronquial obstructivo

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.5 · Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome bronquial obstructivo (SBO): sibilancias y espiración prolongada en <2-3 años, gatillado por virus; recurrente si ≥3 episodios.
- Evaluar gravedad con score de Tal (FR, sibilancias, cianosis, retracción): 0-5 leve, 6-8 moderado, 9-12 grave; y saturometría.
- Tratamiento: salbutamol 2 puff con aerocámara c/10 min por 5 veces (1 h); reevaluar con Tal. Si no mejora repetir 1 h más y agregar prednisona 1-2 mg/kg/día por 3-5 días.
- Hospitalizar si Tal ≥9, saturación <93% tras tratamiento, falla de 2 horas de manejo, apneas o cianosis.
- SBO recurrente: considerar asma del lactante (índice predictivo de asma), corticoide inhalado como mantención; descartar FQ, aspiración, cardiopatía o cuerpo extraño.
- Seguimiento: control en 24-48 h en sala IRA; derivar a broncopulmonar si SBO grave, recurrente sin respuesta o atípico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 18 meses, con 4 episodios de obstrucción bronquial con sibilancias en los últimos 12 meses, todos tratados con salbutamol y uno que requirió hospitalización. Entre los episodios está asintomático y con buen incremento ponderal. Hoy consulta en control, sin dificultad respiratoria. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Salbutamol inhalado diario de forma permanente
B Amoxicilina profiláctica durante el invierno
C Prednisona oral diaria por 3 meses
D Corticoide inhalado de mantención con aerocámara y seguimiento
E No requiere tratamiento, porque hoy está asintomático

Respuesta D. Tres o más episodios obstructivos en el año en un menor de 2 años definen un síndrome bronquial obstructivo recurrente. Con episodios frecuentes o severos se indica corticoide inhalado de mantención con aerocámara. El salbutamol es solo de rescate y el corticoide oral crónico no se usa.

▶ VER CLASE 2.01.1.029 Sinusitis

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.10 · Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

QUÉ HAY QUE SABER

- Sinusitis aguda bacteriana: secreción nasal o tos diurna persistente >10 días sin mejoría, empeoramiento tras mejoría inicial, o inicio grave (fiebre ≥39 °C y rinorrea purulenta ≥3 días).

- Seno etmoidal y maxilar presentes desde el nacimiento; frontal se desarrolla a los 6-10 años. Diagnóstico clínico; Rx de senos no se recomienda de rutina.
- Tratamiento: amoxicilina 80-90 mg/kg/día c/12 h por 10-14 días (o 7 días tras resolución); falla o factores de riesgo: amoxicilina-ácido clavulánico.
- Medidas coadyuvantes: lavado nasal con suero; corticoide intranasal si rinitis alérgica asociada.
- Complicaciones: celulitis periorbitaria/orbitaria, meningitis, absceso cerebral, osteomielitis frontal (tumor de Pott): TC y hospitalizar.
- Seguimiento: control a las 72 h; sinusitis recurrente o crónica (>12 semanas): derivar a ORL y descartar rinitis alérgica, FQ, inmunodeficiencia.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 14

Niño con 10 días de congestión nasal y rinorrea, hace 2 días con fiebre y rinorrea mucopurulenta. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Amoxicilina por 10 días vía oral

B Azitromicina por 5 días

C Cotrimoxazol por 7 días

D Tratamiento sintomático (suero fisiológico nasal)

E Amoxicilina-clavulánico por 14 días

Respuesta A. Diez días de evolución con empeoramiento (fiebre y rinorrea mucopurulenta) cumple criterio de rinosinusitis bacteriana. La primera línea es amoxicilina oral por 7 a 10 días.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 59

Un niño de 8 años presenta un cuadro de 14 días de congestión nasal con rinorrea purulenta, cefalea, sensación febril, asociada a odinofagia y tos con expectoración mucopurulenta. En los últimos días se agrega mayor malestar general y fiebre. Al examen físico presenta rinorrea purulenta abundante, descarga posterior y faringe congestiva y eritematosa, con examen pulmonar normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar tratamiento sintomático con paracetamol

B Iniciar claritromicina oral

C Iniciar ceftriaxona endovenosa

D Iniciar amoxicilina oral

E Solicitar radiografía de tórax y baciloscopías

Respuesta D. Es una rinosinusitis aguda bacteriana, con 14 días de evolución y empeoramiento reciente. Se trata con amoxicilina oral. La tos con expectoración se explica por la descarga posterior y el examen pulmonar es normal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 67

Un niño de 6 años, con antecedente de obstrucción nasal y rinorreas frecuentes, mayor en primavera, presenta un cuadro de 10 días de evolución caracterizado por rinorrea mucosa abundante, tos y picos subfebriles hasta 37,8 °C. Inicialmente tendió a mejorar, sin embargo, desde hace 4 días se produjo un aumento en la secreción nasal, la que en ocasiones tenía mal olor, y se agregó cefalea frontal. Al examen físico está en buenas condiciones, con temperatura: 36,5 °C, FC: 90x' y FR: 15x', se observa faringe eritematosa con descarga posterior y se constata dolor a la percusión de la zona frontal. El examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente y escasos roncus bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Solicitar radiogra:a de senos paranasales

B Iniciar amoxicilina vía oral

C Solicitar TAC de cavidades paranasales

D Iniciar prednisona oral

E Solicitar nasofibroscopía

Respuesta B. Tiene una sinusitis aguda, con alta sospecha de infección bacteriana (por empeoramiento y Gempo de evolución). El diagnóstico es clínico y se trata con amoxicilina oral, como antibiótico de primera línea.

▶ VER CLASE 2.01.1.030 Adenopatías

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.2 · Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH

QUÉ HAY QUE SABER

- Adenopatía: ganglio >1 cm (>1,5 cm inguinal, >0,5 cm epitroclear; cualquier supraclavicular es patológico). Generalizada si ≥2 regiones no contiguas.
- Causas frecuentes: reactivas virales, infección bacteriana local, VEB/CMV, toxoplasmosis, Bartonella, TBC; malignas: leucemia, linfoma, neuroblastoma.
- Banderas rojas: supraclavicular, >2-3 cm, dura, adherida, indolora, crecimiento progresivo, >4-6 semanas, síntomas B (fiebre, sudoración, baja de peso), hepatoesplenomegalia, citopenias.
- Estudio: hemograma con frotis, VHS, LDH, serologías (VEB, CMV, toxoplasma, Bartonella), PPD, Rx tórax (masa mediastínica) y ecografía ganglionar.
- Localizada con signos inflamatorios: tratar como adenitis (cefadroxilo) y controlar en 2 semanas; no usar corticoides antes de descartar linfoma/leucemia.
- Seguimiento: derivar a hematooncología/cirugía para biopsia si banderas rojas o sin regresión en 4-6 semanas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 18

Niño con adenopatías cervicales y granulomas hepatoesplénicos en la ecografía abdominal. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Bartonella henselae
B Toxoplasma gondii
C Virus Epstein-Barr
D Mycobacterium tuberculosis
E Leishmania sp.

Respuesta A. La asociación de adenopatías con granulomas o microabscesos hepatoesplénicos en un niño es característica de la enfermedad por arañazo de gato (Bartonella henselae), que suele seguir al contacto con gatos jóvenes. La toxoplasmosis y el Epstein-Barr causan adenopatías, pero no lesiones focales hepatoesplénicas; la tuberculosis miliar es mucho menos probable.

▶ VER CLASE 2.01.1.031 Anemia ferropriva

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.3 · Anemia Ferropénica: Diagnóstico, Algoritmo Causal (Digestivo, Menstrual, Celíaco) y Terapia Oral vs Endovenosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Anemia ferropriva: la más frecuente en pediatría, peak 6-24 meses y adolescencia. Hb <11 g/dL (6 m-5 años), <11,5 (5-11 años), <12 (12-14 años).
- Factores de riesgo: prematurez/bajo peso, leche de vaca antes del año, dieta pobre en hierro, pérdidas (parásitos, menstruación).
- Laboratorio: anemia microcítica hipocrómica (VCM bajo), ferritina baja (<12 ng/mL), ADE (RDW) alto, saturación de transferrina baja. Diferencial: talasemia (RDW normal, índice de Mentzer <13).
- Tratamiento: sulfato ferroso 3-6 mg/kg/día de hierro elemental en ayunas o lejos de las comidas, por 3-4 meses tras normalizar Hb (para reponer depósitos). Evitar leche y té con el hierro.
- Respuesta esperada: reticulocitosis a los 5-10 días y alza de Hb ≥1 g/dL en 4 semanas; si no responde, revisar adherencia, pérdidas o diagnóstico alternativo.
- Prevención: suplemento de hierro desde 4 meses en lactancia exclusiva (desde 2 meses en prematuros), fórmulas y cereales fortificados (PNAC). Seguimiento: hemograma a las 4 semanas y al terminar.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 106

Un niño de 4 años, con antecedente de ictericia neonatal, que requirió fototerapia, es traído a la urgencia por dolor abdominal y náuseas de 4 días de evolución. Al examen físico destaca ictericia de piel y mucosas, asociado a palidez y en el examen abdominal se objetiva esplenomegalia, con bazo por 3 cm bajo el reborde costal. Su hemograma muestra hematocrito de 20%, hemoglobina de 6,9 g/dl, VCM: 70 fl, 17% de reticulocitos, blancos: 8.000 por mm3 y plaquetas: 200.000 por mm3. El frotis sanguíneo muestra macrocitosis, poiquilocitosis y anisocitosis. En sus pruebas hepáticas destaca bilirrubina 6 mg/dl, con bilirrubina directa de 0,9 mg/dl. **El diagnóstico más probable:**

A Anemia hemolítica
B Leucemia aguda
C Anemia ferropénica
D Anemia por déficit de vitamina B12
E Anemia de Fanconi

Respuesta A. Reticulocitos 17 % y bilirrubina de predominio indirecto: anemia hemolítica regenerativa. Blancos y plaquetas normales descartan leucemia. La ictericia neonatal y la esplenomegalia sugieren una hemolítica congénita, como la esferocitosis hereditaria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 115

Un niño de 9 meses tiene palidez de piel y mucosas, por lo que se solicita un hemograma, que muestra hemoglobina: 9 g/dl, hematocrito: 36%, VCM: 68 fl, glóbulos blancos: 6.500 por mm3, plaquetas: 450.000 por mm3. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Anemia ferropriva
B Anemia por enfermedades crónicos
C Trombocitosis esencial
D Hemoglobinopatía
E Microesferocitosis familiar

Respuesta A. Es una anemia ferropénica clásica, tanto por la edad como por la microcitosis. La hemoglobinopatía es posible, pero mucho menos frecuente; sin un recuento de glóbulos rojos alto, RDW normal y ferritina normal, no hay por qué pensar primero en ella.

▶ VER CLASE 2.01.1.032 Leucemias

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.16 · Leucemias Agudas: Mieloide Aguda (LMA) y Linfoblástica Aguda (LLA): Blastos >20%, Bastones de Auer y Trasplante

QUÉ HAY QUE SABER

- Leucemia: cáncer más frecuente en niños; LLA ~80% (peak 2-5 años). Sospechar ante palidez, fiebre, petequias/equimosis, dolor óseo (cojera nocturna), hepatoesplenomegalia y adenopatías.
- Hemograma: bicitopenia o pancitopenia, blastos en frotis; leucocitos pueden estar bajos, normales o muy altos.

- No dar corticoides antes del diagnóstico (alteran el mielograma). Diagnóstico definitivo con mielograma: >20-25% de blastos.
- Manejo inicial: hidratación, evaluar fiebre y neutropenia (antibióticos EV de amplio espectro), transfusión si sangrado o anemia sintomática; vigilar lisis tumoral (hiperkalemia, hiperuricemia, hiperfosfemia).
- Masa mediastínica (LLA T) puede comprimir vía aérea: Rx tórax antes de sedar.
- Cáncer infantil es GES: derivar con urgencia a centro PINDA de hematooncología; seguimiento por especialista.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 15

Un niño de 11 años presenta un cuadro de astenia y fiebre de algunas semanas de evolución. Al examen físico se aprecia palidez, asociado a esplenomegalia. **¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para continuar el estudio en este paciente?**

A IgM para virus Ebstein Baar
B Hemograma VHS
C Biopsia ganglionar
D IgM para Bartonella henselae
E Tiempos de coagulación

Respuesta B. Fiebre, astenia, palidez y esplenomegalia de semanas en un niño: sospecha de leucemia aguda. El estudio se inicia con el hemograma con frotis, que busca citopenias y blastos; el mielograma viene después, para confirmar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 27

Un niño de 8 años presenta dolores óseos generalizados, malestar general y fiebre de 3 semanas de evolución. Al examen físico se palpa el bazo aumentado de tamaño, se constatan poliadenopatías indoloras y se observan petequias y equimosis generalizadas, mayores en las extremidades inferiores. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?**

A Cintigrafía ósea
B Hemograma
C Biopsia esplénica
D Mielograma
E Cuantificación de inmunoglobulinas

Respuesta D. Dolor óseo, fiebre, adenopatías, esplenomegalia y sangrado cutáneo en un escolar sugieren leucemia aguda, probablemente linfoblástica. El hemograma orienta (citopenias, blastos), pero la confirmación requiere estudio de médula ósea: mielograma (con inmunofenotipo y citogenética), que demuestra 20% o más de blastos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 85

Una niña de 9 meses de edad, estuvo alimentada con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, momento en que inició la alimentación sólida. Sin embargo, la madre, vegana estricta, consideró que la niña no toleraba bien los alimentos, por lo que la mantuvo con leche materna exclusiva hasta ahora. Evoluciona con detención del crecimiento, dificultades para sentarse y hablar, además de estar más hipoactiva de lo normal. Al examen físico, se aprecia pálida y letárgica, con signos vitales normales y sin alteraciones en el examen cardiopulmonar ni abdominal. Se solicitan exámenes, que muestran hemoglobina: 7,9 g/dl, hematocrito: 24%, blancos: 3.700 por mm3, plaquetas: 45.000 por mm3, VHS: 12 mm/h, TSH: 1,2 UI/L, creatininemia: 0,5 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Déficit de vitamina B12
B Anemia hemolítica
C Enfermedad celíaca
D Leucemia aguda
E Fibrosis quística

Respuesta D. Diagnóstico: Leucemia aguda (opción D). :::note Dopamina inhibe la prolactina → antidopaminérgicos (antipsicóticos) pueden causar galactorrea incluso en no embarazadas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 158

Un niño de 10 años es traído a la consulta por aparición de múltiples equimosis y petequias, desde hace 2 semanas, asociadas a palidez. Al examen físico se aprecia pálido, con petequias en las extremidades inferiores y el tronco y múltiples equimosis de gran tamaño en las extremidades inferiores. Además, se palpa hepatomegalia de 3 cm bajo el reborde costal. El diagnóstico más probable es:

A Púrpura trombopénica inmune
B Enfermedad de von Willebrand
C Púrpura de Schönlein Henoch
D Meningococcemia
E Leucemia

Respuesta E. Es una leucemia clásica, con signos de insuficiencia medular (anemia y alteraciones de la hemostasia primaria) y hepatoesplenomegalia. Ninguna de las otras tiene anemia. La meningococcemia es muy agresiva, en cosa de horas o pocos días. La PSH tiene púrpura palpable, alteraciones digestivas, compromiso articular y GNA. la EvW es algo crónico con alteración de la hemostasia primaria. La PTI sí puede tener equimosis y petequias, pero no la hepatomegalia.

▶ VER CLASE 2.01.1.033 Linfomas

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.18 · Linfomas: Linfoma de Hodgkin (Reed-Sternberg, Ann Arbor, Síntomas B) vs Linfomas No Hodgkin (LDGCB y Folicular)

QUÉ HAY QUE SABER

- Linfoma de Hodgkin: adolescentes; adenopatía cervical o supraclavicular indolora, dura, de crecimiento lento, masa mediastínica, síntomas B, prurito.
- Linfoma no Hodgkin: niños menores, crecimiento rápido; Burkitt abdominal (masa, invaginación en >2 años), linfoblástico mediastínico con síndrome de vena cava superior.
- Estudio inicial: hemograma, VHS, LDH, ácido úrico, Rx tórax; biopsia excisional del ganglio confirma (Reed-Sternberg en Hodgkin).
- Urgencias: compresión de vía aérea o vena cava superior, lisis tumoral (hiperuricemia, hiperkalemia, IRA): hidratación y alopurinol/rasburicasa.
- No usar corticoides antes de la biopsia.
- Cáncer infantil es GES: derivar con urgencia a hematooncología pediátrica (PINDA); seguimiento por especialista.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un adolescente de 15 años consulta por una adenopatía supraclavicular izquierda indolora, de consistencia elástica, de 3 cm, que crece desde hace 6 semanas. Refiere sudoración nocturna y baja de 5 kg de peso. La radiografía de tórax muestra ensanchamiento mediastínico. **¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico?**

A Punción aspirativa con aguja fina del ganglio

B Mielograma

C TAC de tórax, abdomen y pelvis

D Serología para virus Epstein-Barr

E Biopsia excisional del ganglio

Respuesta E. Adenopatía supraclavicular, síntomas B y masa mediastínica en un adolescente sugieren linfoma de Hodgkin. El diagnóstico requiere biopsia excisional del ganglio completo, que permite ver la arquitectura y las células de Reed-Sternberg. La punción con aguja fina no basta para clasificar un linfoma. El TAC y el PET sirven para etapificar, después de confirmar.

▶ VER CLASE 2.01.1.034 Neutropenia febril

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.5 · Neutropenia Febril Post-Quimioterapia y Fiebre sin Foco

QUÉ HAY QUE SABER

- Neutropenia febril: T° ≥38,3 °C una vez o ≥38 °C por 1 h, con RAN <500/mm³ (o <1.000 con tendencia a caer), habitualmente post quimioterapia.
- Es urgencia: evaluación rápida, sin tacto rectal ni toma de temperatura rectal; buscar foco (catéter, piel, mucositis, perianal, pulmón).
- Estudio: hemograma, PCR, hemocultivos periférico y de catéter, orina completa y urocultivo, Rx tórax si síntomas.
- Antibiótico empírico EV en <1 h: cefalosporina antipseudomónica (cefepime o ceftazidima) o piperacilina-tazobactam; agregar vancomicina si sospecha de catéter, piel o inestabilidad.
- Alto riesgo: hipotensión, mucositis grave, leucemia en inducción, neutropenia prolongada; considerar antifúngico si fiebre persiste >4-7 días.
- Seguimiento: hospitalizar y derivar al centro oncológico tratante.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 58

Un niño de 7 años, diagnosticado de leucemia linfoblástica aguda, inicia sus ciclos de quimioterapia hace 7 días. Consulta por fiebre asociada a malestar general. Al examen físico presenta temperatura 38,5 °C y frecuencia cardíaca 110 x minuto, sin alteraciones en el examen físico segmentario. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Administrar ceftriaxona intramuscular y controlar en 24 horas

B Indicar antipiréticos y controlar en caso de persistencia de la fiebre

C Administrar antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa

D Solicitar serología para virus de Epstein-Barr y citomegalovirus

E Iniciar amoxicilina por vía oral

Respuesta C. Fiebre 7 días después de iniciar quimioterapia: neutropenia febril hasta demostrar lo contrario. Es una urgencia infectológica que requiere antibióticos endovenosos de amplio espectro con cobertura antipseudomónica durante la primera hora, sin esperar el foco.

▶ VER CLASE 2.01.1.035 Síndrome purpúrico

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.12 · Trombocitopenias y Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) del Adulto y Niño: Criterios, Sangrado y Terapia GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Púrpura: petequias/equimosis por alteración plaquetaria o vascular. Diferenciar con hemograma y frotis: trombocitopenia vs plaquetas normales.
- PTI: niño sano 2-6 años, petequias súbitas tras infección viral, plaquetas aisladas bajas (<100.000), sin hepatoesplenomegalia ni otras citopenias.
- PTI manejo: observación si solo sangrado cutáneo aunque plaquetas <20.000; sangrado mucoso: prednisona 2-4 mg/kg/día o inmunoglobulina 0,8-1 g/kg. Evitar AINE e intramuscular.

- Plaquetas normales con púrpura palpable en extremidades inferiores, artralgia, dolor abdominal: Schönlein-Henoch.
- Banderas rojas: fiebre con petequias y mal estado (meningococcemia), bicitopenia o hepatoesplenomegalia (leucemia; mielograma antes de corticoides), SHU.
- Seguimiento: derivar a hematología si plaquetas <20.000 con sangrado, PTI persistente >3 meses o duda diagnóstica.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 101

Un niño de 5 años cursa un cuadro respiratorio alto desde hace 7 días que ha recibido tratamiento con paracetamol e ibuprofeno. Consulta por aparición de múltiples lesiones cutáneas consistentes en petequias y equimosis en las extremidades y el abdomen, asociadas a epistaxis en algunas oportunidades. Se solicitan exámenes, destacando hemograma con hematocrito: 42%, hemoglobina: 14 g/dL, glóbulos blancos: 9.500/mm³ con 65% linfocitos, 30% neutrófilos y 5% monocitos, plaquetas: 60.000/mm³. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Leucemia linfática aguda

B Meningococcemia

C Púrpura trombocitopénica inmune

D Alteración de la hemostasia secundaria a fármacos

E Púrpura de Schönlein-Henoch

Respuesta C. Trombocitopenia aislada tras una virosis en un niño: PTI. Ninguna otra serie está alterada, lo que aleja la leucemia. La disfunción plaquetaria por AINE y el Schönlein-Henoch tienen plaquetas normales.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 159

Un niño de 8 años acude al servicio de urgencia por un cuadro de epistaxis, que respondió al tratamiento con taponamiento nasal anterior. Al examen físico tiene petequias generalizas y equimosis, principalmente en las extremidades inferiores. Su hemograma muestra hemoglobina 12 g/dl, hematocrito: 36%, plaquetas: 10.000 por mm3 y glóbulos blancos: 5.600 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Leucemia aguda

B Púrpura trombocitopénico inmune

C Púrpura trombocitpénico trombótico

D Hemofilia

E Enfermedad de Von Willebrand

Respuesta B. Diagnóstico: Púrpura trombocitopénico inmune (opción B). Tiene un PTI clásico: alteración de hemostasia primaria, con trombocitopenia aislada. :::warning Púrpura + FIEBRE = URGENCIA → descartar meningococcemia (instalación aguda, grave) o leucemia aguda (fiebre + adenopatías + esplenomegalia + anemia de días a semanas).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 146

Un niño de edad escolar presenta aparición de petequias y equimosis en el dorso y en las extremidades, con epistaxis y gingivorragia, que comenzaron hace 4 días. Se solicita un hemograma, que demuestra hematocrito de 35%, con hemoglobina de 11,8 g/dl, blancos: 9.000 por mm3, con fórmula diferencial normal y plaquetas: 18.000 por mm3. Además presenta INR: 1,1 y protrombinemia de 80%. El diagnóstico más probable es:

A Púrpura de Schönlein Henoch

B Púrpura trombocitopénico inmune

C Leucemia aguda

D Meningococcemia

E Hemofilia

Respuesta B. Diagnóstico: Púrpura trombocitopénico inmune (opción B). Es un PTI clásico, con el hemograma característico: trombocitopenia asilada. :::warning Púrpura + FIEBRE = URGENCIA → descartar meningococcemia (instalación aguda, grave) o leucemia aguda (fiebre + adenopatías + esplenomegalia + anemia de días a semanas).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 111

Un paciente de 6 años, con historia de que hace dos semanas presentó cuadro caracterizado por rinorrea, odinofagia y tos, el cual fue manejado adecuadamente. Actualmente consulta por presencia de sangrado de encías, sin otros síntomas. Al examen físico destaca en buenas condiciones generales, con petequias en tronco y extremidades, resto normal. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina 12 mg/dL, leucocitos 8.000/mm3 y plaquetas 10.000/mm3. El diagnóstico más probable es:

A Purpura trombocitopénico trombótico

B Hemofilia A

C Púrpura de Schonlein Henoch

D Purpura trombocitopénico inmune

E Enfermedad de Von Willebrand

Respuesta D. Diagnóstico: Purpura trombocitopénico inmune (opción D). PTI de libro. :::warning Púrpura + FIEBRE = URGENCIA → descartar meningococcemia (instalación aguda, grave) o leucemia aguda (fiebre + adenopatías + esplenomegalia + anemia de días a semanas).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 47

Una paciente de 12 años, sin antecedentes, consulta por cuadro de hemorragia gingival al lavarse los dientes, asociado a equimosis frente a pequeños traumatimos desde hace 2 semanas. Al examen físico destacan dichas equimosis y petequias generalizadas, sin otros hallazgos. Se solicita hemograma donde destaca hemoglobina de 12mg/dL, leucocitos de 7.000/mm3 y plaquetas de 4000/ mm3. El tratamiento de elección en este caso es:

A Transfusión de plaquetas
B Esplenectomía
C Corticoides
D Inmunoglobulina no específica
E Administrar crioprecipitado

Respuesta C. Tiene un PTI agudo, pero por tener menos de 20.000 plaquetas, hay que indicarle corticoides. En general solo se observa. Si tuviese hemorragias graves (ej: HDA o hemorragia intracraneal), se debería dar IgG ev. Si fuera crónico: siempre corticoides y si fallan: esplenectomía.

▶ VER CLASE 2.01.1.036 Trastornos coagulación

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.13 · Coagulopatías Congénitas: Hemofilia A (Factor VIII), Hemofilia B (Factor IX) y Enfermedad de von Willebrand

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastornos de coagulación: hemofilia A (déficit factor VIII) y B (IX), ligadas al X en varones: hemartrosis, hematomas musculares, sangrado post circuncisión o extracción dental.
- Enfermedad de von Willebrand: la más frecuente hereditaria; sangrado mucocutáneo (epistaxis, gingivorragia, menorragia).
- Laboratorio: hemofilia TTPA prolongado con TP y plaquetas normales; vW con TTPA normal o prolongado y tiempo de sangría/PFA alterado; corrige con plasma normal si es déficit.
- Manejo inicial: compresión, frío e inmovilización de hemartrosis; no AINE ni inyecciones IM; desmopresina en hemofilia A leve y vW tipo 1; ácido tranexámico en sangrado mucoso.
- Sangrado grave o TEC en hemofílico: administrar concentrado de factor antes de imágenes (meta 100%).
- Seguimiento: derivar a hematología (hemofilia es GES); educación familiar y profilaxis con factor.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 159

Un niño de 2 años presenta tendencia a las hemorragias, ya que sangra con facilidad y presenta múltiples equimosis. En el examen físico, se observan extremidades inferiores con equimosis en distinto grado de resolución, algunas de gran tamaño. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma con recuento de plaquetas normal, TP normal y TTPA alargado. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Púrpura trombocitopénica inmune
B Hemofilia
C Enfermedad de von Willebrand
D Enfermedad de Glanzmann
E Púrpura trombocitopénica trombótica

Respuesta B. Plaquetas normales, TP normal y TTPA alargado: vía intrínseca. En un niño pequeño con equimosis grandes, la hemofilia es lo más probable. PTI y PTT tienen plaquetas bajas; Glanzmann y von Willebrand alteran la hemostasia primaria y habitualmente no alargan el TTPA, salvo algunas formas de von Willebrand.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 35

Niño con equimosis frecuentes, TTPA prolongado al triple, hermano fallecido por hemorragia intracraneal. **¿Cuál es el examen para el diagnóstico?**

A Tiempo de hemorragia (Duke)
B Recuento de plaquetas y función plaquetaria
C Factor de Von Willebrand y cofactor de ristocetina
D Proteínas C y S
E Factores de coagulación VIII y IX

Respuesta E. Varón, hermano fallecido por hemorragia y TTPA francamente prolongado: hemofilia. El diagnóstico y la distinción entre A y B se hacen dosificando los factores VIII y IX. El perfil de von Willebrand se pide ante sangrado de mucosas con TTPA normal o levemente largo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 23

Un niño de 8 años presenta epistaxis con frecuencia y, además, tiene antecedente de haber presentado sangramiento bucal prolongado, después de una extracción dental. Al examen físico, se objetivan múltiples equimosis en las piernas y rodillas. Como antecedente, su madre refiere que ella presenta reglas abundantes y también cierta tendencia a tener equimosis. Se solicitan exámenes que muestran protrombinemia: 85%, TTPA: 38 segundos, hemograma con hematocrito: 33%, hemoglobina: 11 g/dl, VCM: 88 ft, glóbulos blancos: 8.000 por mm3 y plaquetas: 323.000 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Hemofilia
B Trombocitopenia inmune
C Enfermedad de von Willebrand
D Síndrome antifosfolípidos
E Niño sano

Respuesta C. Diagnóstico: Enfermedad de von Willebrand (opción C). La epistaxis o sangrado nasal es una consulta frecuente en urgencias.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 135

Un recién nacido, presenta un cefalohematoma de gran tamaño, al momento de nacer. Además, presenta hematoma del sitio de punción de la muestra venosa. Sus padres son asintomáticos, pero uno de sus tíos murió en el periodo neonatal por hemorragia intracraneal. Entre sus exámenes, destaca TP: 70%, TTPA: 65 segundos, hemograma con hematocrito 50%, blancos: 8.400 por mm3 y plaquetas: 350.000 por mm3. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A Agregometría plaquetaria
B Factores de coagulación VIII y IX
C Estudio de trombofilia
D Biopsia de médula ósea
E Frotis de sangre periférica

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Factores de coagulación VIII y IX).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 77

Escolar de 8 años, es traído por su madre ya que desde hace años presenta equimosis frente a pequeños traumatismos y en una ocasión presentó un hematoma en muslo al jugar en el colegio. Actualmente presenta sangramiento gingival, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia dicho sangramiento, asociado a equimosis en extremidades. Se solicitan exámenes que muestran hemoglobina 12mg/dL, leucocitos 6.000/mm3, plaquetas 230.000/mm3, tiempo de protrombina normal y tiempo de tromboplastina parcial activada prolongada. El diagnóstico más probable en este caso es:

A Enfermedad de Von Willebrand
B Enfermedad de Bernard Soulier
C Enfermedad de Glanzmann
D Hemofilia
E Escorbuto

Respuesta A. Esta pregunta está muy difícil, ya que la gingivorragia puede estar en la EvW y es más frecuente en ella que en la hemofilia. Además la EvW puede alargar levemente el TTPA. Por ser niño, por tener un hematoma profundo y por tener el TTPA largo, podría ser hemofilia. Sin embargo, que no haya tenido hemartrosis y que solo haya tenido un hematoma muscular, más los otros síntomas, lo más probable es que sea un von Willebrand. Habría que ver bien cómo estaba redactada la pregunta original. Revisar...

▶ VER CLASE **2.01.1.037** **Tumores sólidos** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.11 · Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumores sólidos más frecuentes: SNC (1°), neuroblastoma, tumor de Wilms, linfomas, retinoblastoma, sarcomas óseos y de partes blandas.
- Neuroblastoma: <2 años, masa abdominal que cruza línea media, calcificaciones, catecolaminas urinarias elevadas, equimosis periorbitaria, opsoclono-mioclono.
- Tumor de Wilms: 2-5 años, masa abdominal lisa en flanco que no cruza línea media, en niño sano; HTA y hematuria; asociado a aniridia y hemihipertrofia.
- Retinoblastoma: leucocoria, estrabismo. Osteosarcoma/Ewing: dolor óseo persistente nocturno, masa en adolescente.
- Manejo inicial: ecografía abdominal ante masa, evitar palpación repetida (riesgo de rotura en Wilms), hemograma, LDH, función renal.
- Cáncer infantil es GES: derivar con urgencia a oncología pediátrica (PINDA).

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 109

Un niño de 7 años presenta orinas oscuras desde hace 5 días, sin otros síntomas. Al examen físico se palpa una masa abdominal en el flanco derecho de 10 cm de diámetro. Los exámenes muestran bilirrubina 1,0 mg/dL, creatinina 1,1 mg/dL y sedimento de orina con 30 a 40 glóbulos rojos por campo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Riñón poliquístico
B Neuroblastoma
C Hepatoblastoma
D Tumor de Wilms
E Linfoma

Respuesta D. Masa en el flanco con hematuria en un niño sano obliga a pensar en tumor de Wilms (nefroblastoma), el tumor renal más frecuente en pediatría. El neuroblastoma suele dar compromiso del estado general, cruzar la línea media y calcificarse; el hepatoblastoma no produce hematuria. No se debe palpar repetidamente ni biopsiar: se estudia con imágenes y se deriva.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 77

Un niño de 4 años, presenta orinas oscuras, desde hace 7 días. Al examen físico se palpa una masa abdominal sólida, en relación al flanco izquierdo, sin otras alteraciones. Se solicitan exámenes de orina, que muestran sedimento con 2 leucocitos por campo, 35 eritrocitos por campo, sin bacterias ni cristales. El urocultivo resulta negativo. Su hemograma es normal y su creatinina es 0,7 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Riñón poliquístico
B Neuroblastoma
C Hepatoblastoma
D Tumor de Wilms
E Estenosis pielocalicilar

Respuesta C. Diagnóstico: Hepatoblastoma (opción C).

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 32

Niño de 4 años con orinas oscuras, masa palpable en flanco izquierdo y hematuria sin leucocituria. ¿El diagnóstico más probable es?

A Tumor de Wilms
B Neuroblastoma
C Quiste renal simple
D Hidronefrosis severa
E Linfoma retroperitoneal

Respuesta A. Diagnóstico: Tumor de Wilms (opción A). Tumor de Wilms.

▶ VER CLASE `2.01.1.038` **Constipación** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.2 · Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Constipación: ≥2 criterios de Roma IV por ≥1 mes: ≤2 deposiciones/semana, retención, defecación dolorosa o dura, heces de gran diámetro, masa fecal rectal, encopresis.
- 95% funcional; peak en retiro del pañal e ingreso escolar. Disquecia del lactante es normal (esfuerzo y llanto antes de deposición blanda).
- Banderas rojas de causa orgánica: retraso en eliminación de meconio >48 h (Hirschsprung), distensión, vómitos biliosos, sangre, falla de crecimiento, alteraciones neurológicas o de columna.
- Desimpactación: PEG 3350 1-1,5 g/kg/día por 3-6 días o enemas (no fosfato en <2 años). Mantención: PEG 0,4-0,8 g/kg/día o lactulosa 1-2 ml/kg/día por ≥2 meses.
- Medidas: fibra y agua, entrenamiento de hábito defecatorio (sentarse 5-10 min post comidas), calendario de deposiciones, refuerzo positivo.
- Seguimiento: control mensual en APS; retirar laxante gradualmente tras 1 mes sin síntomas; derivar a gastroenterología si no responde o hay banderas rojas.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 165

Niño de 7 años que desde hace 3 años presenta deposiciones cada vez más infrecuentes y duras. Hace algunas semanas empeoran los síntomas, por lo que se inicia lactulosa 15 mililitros al día, sin lograr cambios. Además, comienza a manchar frecuentemente los calzoncillos con deposiciones. **¿Cuál es la causa más probable de la falta de respuesta en este paciente?**

A Dosis insuficiente de laxante
B Dieta baja en fibra
C Enfermedad de Hirschsprung
D Presencia de fecaloma
E Concomitancia de patología psiquiátrica

Respuesta D. Constipación progresiva que no responde a un laxante de mantención, y que ahora se acompaña de manchado fecal: es un fecaloma, con pseudoincontinencia por rebosamiento. Un laxante de mantención no desimpacta; primero hay que sacar el fecaloma, con polietilenglicol oral, y recién después mantener.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 163

Un niño de 4 años presenta incontinencia fecal, en algunas ocasiones, desde hace dos meses. Sin embargo, en otras ocasiones, pasan muchos días sin defecar y cuando lo hace, sus deposiciones son duras y caprinas. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Niño sano
B Atresia duodenal
C Constipación funcional
D Megacolon aganglionótico
E Malrotación intestinal

Respuesta C. Tiene una constipación funcional clásica, probablemente complicada con un fecaloma (por la incontinencia fecal). Es la causa más frecuente de constipación en niños y se mejora con laxantes y formación de hábitos de defecación.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 66

Una niña de 4 años acude al servicio de urgencia debido a que no ha defecado en 5 días. La madre refiere que recientemente presentó una infección viral en la que estuvo muy inapetente, rechazando la mayoría de los alimentos que se le ofrecían. Sin embargo, actualmente se encuentra de buen ánimo y con buen apetito. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es la conducta más adecuada para su manejo en este momento?

A Vaselina líquida por vía oral
B Hidróxido de magnesio por vía oral
C Enema evacuante de lactulosa
D Polie2lenglicol 3350 vía oral
E Gastroclisis con solución salina

Respuesta D. Es una constipación aguda funcional, probablemente secundaria a la menor ingesta durante la infección viral, sin signos de complicación. El manejo de elección es la desimpactación por vía oral con polietilenglicol 3350, por su eficacia y seguridad. La vaselina líquida se evita por riesgo de aspiración, y los enemas y la gastroclisis se reservan para casos de falla del tratamiento oral.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 13

Niña 3 años con fisura anal resuelta, continua con constipación cual es el manejo adecuado:

A Lactulosa
B PEG (para desimpactar) sgy era aumentar consumo de fibra. Esq aumentar consumo de fibra va junto con aumentar consumo de agua
C colonoscopía
D Agua 2L e. Aumentar consumo de fibra
E Control sano habitual

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: PEG (para desimpactar) sgy era aumentar consumo de fibra. Esq aumentar consumo de fibra va junto con aumentar consumo de agua (opción B).

▶ VER CLASE **2.01.1.039** **Diarrea aguda y en vías de prolongación** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Gastroenterología 6.1 · Diarrea Aguda y Crónica en el Niño
Pediatría 18.11 · Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico

QUÉ HAY QUE SABER

- Diarrea aguda: ≥3 deposiciones líquidas/día por <14 días; rotavirus y norovirus las principales causas. Prolongada 7-14 días; persistente >14 días.
- Evaluar hidratación (OMS): conciencia, ojos, boca/sed, signo del pliegue. Sin deshidratación <5%, moderada 5-10%, grave >10% o shock.
- Plan A (sin deshidratación): continuar alimentación, SRO 10 ml/kg por deposición líquida. Plan B (moderada): SRO 50-100 ml/kg en 4 h. Plan C (grave): SF o Ringer 20 ml/kg EV en bolos hasta 100 ml/kg.
- Zinc 10-20 mg/día por 10-14 días; probióticos pueden acortar la duración. No usar antiespasmódicos ni loperamida; antibióticos solo en disentería con compromiso, cólera, Shigella o <3 meses.
- Diarrea prolongada: descartar intolerancia secundaria a lactosa, parasitosis (Giardia); mantener lactancia.

- Seguimiento: control en 24-48 h si plan B; reconsultar si vómitos persistentes, sangre, decaimiento u oliguria.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 74

Niño de 2 años con gastroenteritis aguda de 24 horas de evolución, con vómitos y diarrea. Sin fiebre alta, sin sangre en las deposiciones, con mucosas hidratadas, llenado capilar normal, y orina presente. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Hospitalización y suero endovenoso
B Sales de rehidratación oral, fraccionadas, en el domicilio
C Ayuno absoluto por 6 horas
D Antibióticos orales empíricos
E Loperamida

Respuesta B. Sin signos de deshidratación (mucosas hidratadas, llenado capilar normal, orina presente): manejo con Plan A, sales de rehidratación oral fraccionadas en domicilio. La loperamida está contraindicada en menores de 2 años.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 10 meses con diarrea acuosa de 3 días, sin sangre. Al examen está irritable, llora sin lágrimas, tiene las mucosas secas y los ojos hundidos, y ha perdido el 7 % de su peso. Bebe con avidez pequeñas cantidades de líquido que se le ofrecen. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A Plan A: SRO 100–200 mL tras cada deposición, en casa
B Plan B: SRO 50–100 mL/kg en 4–6 horas, reevaluando
C Plan C: suero fisiológico 20 mL/kg EV en bolo
D SRO más loperamida para reducir las pérdidas
E SRO más ciprofloxacino oral por 3 días

Respuesta B. Pérdida del 7 % del peso, mucosas secas, ojos hundidos y llanto sin lágrimas: deshidratación moderada. Como tolera la vía oral, corresponde el Plan B con SRO 50–100 mL/kg en 4–6 h. No requiere suero EV (no hay shock ni intolerancia oral), la loperamida está contraindicada y no hay disentería que justifique antibiótico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 76

Un niño de 18 meses, desde hace 24 horas, presenta fiebre hasta 38,7°C, asociado a episodios de vómitos alimentarios y seguido de diarrea acuosa abundante, con múltiples deposiciones. Al examen físico, se ve de buen aspecto, hidratado, tiene T°:37,2°C y frecuencia cardíaca normal. Su examen abdominal muestra abdomen blando, depresible e indoloro, con aumento de los ruidos hidroaéreos. Se realiza examen de deposiciones con tiras reactivas, que resultan positivos para rotavirus y Clostridium difficile (Clostridioides difficile). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Probar tolerancia y rehidratación por vía oral
B Administrar suero fisiológico por vía endovenosa
C Iniciar metronidazol oral
D Iniciar ceftriaxona endovenosa
E Iniciar vancomicina endovenosa

Respuesta A. Manejo de Diarrea Aguda con Portación Asintomática de Clostridium difficile: Un niño con diarrea aguda por rotavirus y portación asintomática de Clostridium difficile no requiere tratamiento para C. difficile. La portación asintomática en niños es frecuente y no suele complicarse. El metronidazol no ha demostrado mayor utilidad en estos casos. El manejo de este caso se centra en la diarrea por rotavirus con tolerancia oral y rehidratación oral.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 146

Lactante de 10 meses con diarrea acuosa de 3 días de evolución, que mejora tras rehidratación oral. Hemograma y electrolitos: normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de la gastroenteritis?

A Gastroenteritis bacteriana (Salmonella)
B Gastroenteritis por Rotavirus
C Infección urinaria
D Enfermedad celíaca de debut
E Fibrosis quística

Respuesta B. Gastroenteritis en lactante de 10 meses: Rotavirus es el agente más frecuente (diarrea acuosa, electrolitos normales, responde bien a rehidratación oral, curso benigno). La gastroenteritis bacteriana típicamente tiene fiebre alta y sangre. Rotavirus tiene vacuna desde los 2 meses.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 134

Un niño de 7 meses de edad es hospitalizado por una bronquilitis aguda. Al quinto día de la hospitalización, presenta fiebre y diarrea acuosa abundante, de olor ácido, sin sangre, de cerca de 6 deposiciones líquidas al día. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A Escherichia coli
B Shiguella
C Clostridium difficile
D Rotavirus
E Enterovirus

Respuesta D. Las diarreas hospitalarias en niños suelen ser virales. Además una bronquiolitis aguda no tiene por qué recibir ATB, como para pensar en C. difficile

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 121

Un niño de 11 meses de edad presenta un cuadro de fiebre, hasta 38,7 grados celsius, asociado a diarrea acuosa abundante, con deposiciones explosivas, ácidas, más irritabilidad importante.

A Rotavirus
B Enterovirus
C Escherichia coli
D Shigella
E Adenovirus

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Rotavirus). El rotavirus es la causa más frecuente de diarrea acuosa febril en lactantes. :::warning Los jugos, bebidas gaseosas y líquidos hiperosmolares están contraindicados: prolongan la diarrea.

▶ VER CLASE 2.01.1.040 Diarrea crónica

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.1 · Diarrea Aguda y Crónica en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Diarrea crónica: >4 semanas. Diarrea crónica inespecífica del preescolar (1-4 años): niño que crece bien, deposiciones con restos de alimentos, asociada a exceso de jugos.
- Causas orgánicas: enfermedad celíaca, giardiasis, intolerancia a lactosa, alergia a proteína de leche de vaca, fibrosis quística, EII, post infecciosa.
- Banderas rojas: falla de crecimiento, sangre, diarrea nocturna, distensión, anemia, hipoalbuminemia.
- Estudio inicial: hemograma, parasitológico seriado, leucocitos fecales, Sudán (esteatorrea), pH y sustancias reductoras, IgA total + antitransglutaminasa IgA, test del sudor si corresponde.
- Manejo inicial: alimentación adecuada sin restricción injustificada, limitar jugos; tratar causa identificada (metronidazol en giardiasis, dieta sin gluten tras confirmar celiaquía).
- Seguimiento: derivar a gastroenterología pediátrica si hay compromiso nutricional, sospecha de celiaquía (biopsia), EII o FQ.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 62

Niño de 3 años presenta diarrea de 3 meses de evolución, intermitente, generalmente acuosa, pero que en ocasiones contiene escasos restos vegetales. Ha subido 600 gramos en ese periodo y su talla es 90 cm. Tiene signos vitales normales, se aprecia hidratado y su examen abdominal muestra un abdomen blando, depresible e indoloro, sin visceromegalia ni otras alteraciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Diarrea crónica inespecífica
B Enfermedad celíaca
C Enteropatía perdedora de proteínas
D Alergia a la proteína de la leche de vaca
E Intolerancia a los disacáridos

Respuesta A. Diarrea intermitente con restos vegetales en un niño sano, que sigue creciendo y está hidratado, sin ningún otro hallazgo: diarrea crónica inespecífica, por exceso de jugos hiperosmolares. No necesita exámenes: la conducta es suspenderlos.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Preescolar de 4 años de una zona rural consulta por diarrea crónica de 2 meses, con abundante flatulencia y dolor abdominal tipo cólico. Dos hermanos tienen síntomas similares. Crece en un percentil bajo pero estable. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y su tratamiento?**

A Diarrea crónica inespecífica; suspender los jugos
B Enfermedad celíaca; dieta sin gluten
C Giardiasis; tinidazol (o metronidazol)
D Fibrosis quística; enzimas pancreáticas
E Alergia a la proteína de leche de vaca; fórmula hidrolizada

Respuesta C. Diarrea crónica con flatulencia y dolor cólico en un preescolar rural, con convivientes afectados: giardiasis. Se confirma con parasitológico seriado (3 muestras) y se trata con tinidazol o metronidazol. Puede dar malabsorción idéntica a la celíaca, por lo que siempre se descarta antes.

▶ VER CLASE 2.01.1.041 Dolor abdominal recurrente

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.2 · Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Dolor abdominal recurrente: ≥4 episodios en 2 meses que interfieren con la actividad; mayoría funcional (Roma IV: dispepsia funcional, SII, migraña abdominal, dolor abdominal funcional).
- Funcional: periumbilical, sin relación con comidas, examen normal, crecimiento normal, gatillantes psicosociales.
- Banderas rojas: dolor que despierta, lejos del ombligo, vómitos biliosos, disfagia, sangrado digestivo, baja de peso, fiebre, diarrea nocturna, artritis, historia familiar de EII o celiaquía.

- Estudio básico: hemograma, VHS/PCR, orina completa y urocultivo, parasitológico, perfil hepático, antitransglutaminasa IgA; ecografía si dolor localizado.
- Manejo inicial: explicar y validar el dolor, reducir estrés, tratar constipación si existe, dieta regular; evitar estudios innecesarios.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología si banderas rojas o estudio alterado; a psicología si gatillante emocional relevante.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Escolar de 8 años con 6 meses de episodios de dolor periumbilical varias veces por semana, que no lo despiertan en la noche y suelen aparecer antes de ir al colegio. Crece en percentil 50 de peso y talla. Examen físico, hemograma, VHS, orina completa y parasitológico seriado normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Endoscopía digestiva alta con biopsias

B TAC de abdomen y pelvis

C Omeprazol empírico por 3 meses

D Diagnosticar dolor abdominal funcional, educar a la familia y abordar los factores psicosociales

E Erradicación empírica de Helicobacter pylori

Respuesta D. Dolor periumbilical recurrente, sin signos de alarma (dolor nocturno o lejos del ombligo, baja de peso, vómitos, sangrado, fiebre) y con exámenes básicos normales es un dolor abdominal funcional. Se maneja con educación, validación del síntoma y apoyo psicosocial, evitando estudios invasivos innecesarios.

▶ VER CLASE 2.01.1.042 Fibrosis quística

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.1 · Diarrea Aguda y Crónica en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Fibrosis quística: autosómica recesiva (mutación CFTR, ΔF508); infecciones respiratorias recurrentes, tos crónica, insuficiencia pancreática con esteatorrea y desnutrición.
- Sospechar: íleo meconial en RN, prolapso rectal, SBO/neumonías a repetición, sabor salado de la piel, pólipos nasales, deshidratación hiponatrémica con alcalosis metabólica.
- Diagnóstico: test del sudor con cloro ≥60 mmol/L en 2 muestras (30-59 dudoso); confirmación genética. FQ es GES.
- Manejo inicial: apoyo nutricional hipercalórico, enzimas pancreáticas, vitaminas liposolubles (A, D, E, K), kinesioterapia respiratoria diaria.
- Colonización por S. aureus y Pseudomonas aeruginosa: cultivos periódicos de expectoración y erradicación por especialista.
- Seguimiento: derivar a centro de FQ con equipo multidisciplinario (broncopulmonar, gastroenterología, nutrición).

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 6

Lactante de 4 meses con infecciones respiratorias a repetición, deposiciones grasas malolientes y retraso pondoestatural. La madre refiere que el sudor del niño "sabe salado". **¿Cuál es el examen diagnóstico de elección?**

A Broncoscopía

B Test del sudor (electrolitos en sudor)

C Test de metacolina

D TAC de tórax de alta resolución

E Espirometría

Respuesta B. Infecciones respiratorias recurrentes, más esteatorrea, más mal incremento de peso, más el detalle clásico del sudor salado: fibrosis quística. El examen diagnóstico es el test del sudor, con cloro mayor o igual a sesenta milimoles por litro.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 135

Niño de 8 meses que sufre desde hace 6 meses diarrea pastosa, abundante. Tiene también antecedente de episodios bronquiales obstructivos y 4 cuadros de infecciones respiratorias, que han requerido de hospitalización. Cuál es el diagnóstico de sospecha?

A Enfermedad celiaca

B Enteropatía perdedora de proteínas

C Enfermedad de cilio inmóvil

D Fibrosis quística

E Alergia a la proteína de la leche de vaca

Respuesta D. Tanto por las infecciones respiratorias, como por la malabsorción es una fibrosis quística. Las demás opciones producen solo síntomas digestivos (A, B y E) o solo neumonías (C).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 56

Un lactante de 7 meses, con antecedente de haber sido hospitalizado en varias opor- tunidades por cuadros respiratorios febriles, presenta diarrea de algunos meses de evo- lución, asociada a esteatorrea y mal incremento ponderal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Enfermedad celíaca
B Inmunodeficiencia primaria
C Fibrosis quística
D Alergia a la proteína de la leche de vaca
E Giardiasis intestinal

Respuesta C. La FQ suele producir neumonías bacterias (S. aureus y P. aureginosa) y un síndro- me de malabsorción.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 151

Un niño de 8 meses de edad ha presentado 5 cuadros de bronquitis obstructiva y además ha presentado diarrea acuosa de 2 meses de evolución. No ha subido de peso en dicho periodo. ¿Qué examen debe realizarse?

A Anticuerpos antitransglutaminasa
B Niveles plasmáticos de IgA
C Test del sudor
D Elisa VIH
E Colonoscopía

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Test del sudor). Sospechar una fibrosis quística. Se diagnostica con test del sudor.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 114

Un lactante de 26 días presenta deposiciones abundantes y frecuentes con visualización de gotas de grasa. Además, sus padres comentan que al besarla su piel tiene un sabor salado. El resto del examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar la sospecha diagnóstica?

A Colonoscopía con biopsia por succión
B Ecogra:a abdominal
C Endoscopía diges2va alta con biopsia de duodeno
D Niveles plasmá2cos de 17-hidroxiprogesterona
E Determinación de electrolitos en el sudor

Respuesta E. La sospecha es una fibrosis quística, cuya clínica se caracteriza por infecciones respiratorias, malabsorción intestinal y puede tener piel salada. El diagnóstico se hace con el test del sudor, que muestra aumento del cloro en sudor. - Cloro > 60 mEq/L: confirma diagnóstico. - Cloro 30-60 mEq/L: sospecha intermedia. Se repite examen y se estudia genéticamente. - Cloro < 30 mEq/L: descarta fibrosis quística.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 156

Una niña de 30 días de vida con mal incremento ponderal presenta deposiciones amarillas, abundantes y oleosas. Los padres refieren que su piel tiene un sabor salado. ¿Cuál es el examen más adecuado para realizar el diagnóstico?

A Ecografía abdominal
B Colonoscopía
C Anticuerpos anti-transglutaminasa y endoscopía digestiva alta
D Electrolitos en sudor
E Hemograma y pruebas de función renal

Respuesta D. Diagnóstico: Electrolitos en sudor (opción D). Se sospecha una fibrosis quística, que se estudia con el test del sudor, que mide cloro en el sudor.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 125

Lactante con bronquitis a repetición, esteatorrea y anemia ferropénica:

A Fibrosis Quística
B Enfermedad celiaca
C Inmunodeficiencia primaria
D Control sano habitual
E Derivar a especialista

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Fibrosis Quística).

▶ VER CLASE | 2.01.1.043 | **Hemorragia digestiva** | DX ESPECÍFICO | TX INICIAL | SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 5.3 · Hemorragia Digestiva Alta y Baja

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemorragia digestiva: primero confirmar que es sangre y de origen digestivo (descartar epistaxis, alimentos rojos, sangre materna deglutida en RN: test de Apt).
- Alta (sobre ángulo de Treitz): hematemesis o melena; causas: esofagitis, gastritis por AINE/estrés, úlcera, várices (hipertensión portal), Mallory-Weiss.

- Baja por edad: RN ECN y vólvulo; lactante fisura anal (la más frecuente), alergia a proteína de leche de vaca, invaginación (deposición en jalea de grosella); preescolar pólipo juvenil, divertículo de Meckel (sangrado indoloro masivo).
- Manejo inicial: ABC, 2 vías venosas, hemograma, grupo y Rh, pruebas de coagulación, bolo SF 20 ml/kg, transfusión si inestable; omeprazol EV si HDA; octreotide si várices.
- Hospitalizar si inestabilidad hemodinámica, caída de Hb, sangrado activo; endoscopía alta/colonoscopía o cintigrafía con Tc99 (Meckel) por especialista.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología/cirugía infantil.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 11

Niño de 6 años, sin antecedentes, es traído por presentar sangrado rectal fresco en gotas al final de las deposiciones, no asociado a dolor ni a otros síntomas. Al examen físico se encuentra con índice de masa corporal adecuado para su edad, abdomen blando, depresible y no doloroso, con ruidos hidroaéreos presentes. **¿Cuál es el diagnóstico más probable en este caso?**

A Úlcera rectal solitaria
B Hemorroides
C Divertículo de Meckel
D Pólipo juvenil
E Fisura anal

Respuesta D. Escolar sano, sin ninguna otra alteración, con sangrado rectal escaso, en gotas y sin dolor: pólipo juvenil, un hamartoma benigno. Se confirma y se trata en el mismo acto con colonoscopía y polipectomía. El divertículo de Meckel sangra de forma más abundante y en niños más pequeños; la fisura anal duele.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 165

Niño de 2 años con diarrea disentérica desde hace 4 días tras consumir una hamburguesa casera. Hoy está pálido, decaído y con disminución marcada de la diuresis. Los exámenes muestran hemoglobina 6,5 g/dL, plaquetas 42.000/mm³, creatinina 2,8 mg/dL, y esquistocitos abundantes en el frotis. **¿Cuál es la sospecha diagnóstica, y qué tratamiento está contraindicado?**

A Invaginación intestinal; está contraindicada la ecografía
B Síndrome hemolítico urémico; están contraindicados los antibióticos
C Púrpura trombocitopénico inmune; están contraindicados los corticoides
D Apendicitis perforada; está contraindicada la laparotomía
E Sepsis bacteriana; está contraindicada la hidratación endovenosa

Respuesta B. Diarrea sanguinolenta previa más anemia hemolítica microangiopática (esquistocitos), trombocitopenia e injuria renal aguda oligúrica: síndrome hemolítico urémico. Los antibióticos están formalmente contraindicados, porque lisan la bacteria y liberan más toxina Shiga a la circulación.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 11

Un paciente de 6 años, sin antecedentes, es traído por presentar sangrado rectal fresco en gotas al final de las deposiciones, no asociado a dolor ni a otros síntomas. Al examen físico tiene índice de masa corporal adecuado para su edad, abdomen blando, depresible e indoloro, con ruidos hidroaéreos presentes. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Úlcera rectal solitaria
B Hemorroides
C Divertículo de Meckel
D Pólipo juvenil
E Fisura anal

Respuesta D. Hematoquecia indolora, intermitente y escasa en un preescolar o escolar sano sugiere pólipo juvenil, un hamartoma colorrectal que es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja indolora entre los 2 y 10 años. La fisura anal duele al defecar; el Meckel da sangrado abundante; las hemorroides son raras en niños. Se diagnostica y reseca por colonoscopía.

▶ VER CLASE 2.01.1.044 Hepatomegalia

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.25 · Inmunodeficiencias Primarias, Infecciones Recurrentes, Hepatomegalia e Interpretación del Hemograma Pediátrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Hepatomegalia: borde hepático >3,5 cm bajo reborde costal en RN, >2 cm en lactantes o >1 cm en niños mayores; confirmar con altura hepática (descartar ptosis por hiperinsuflación).
- Causas: infecciosas (hepatitis virales, VEB, CMV), congestivas (insuficiencia cardíaca), infiltrativas (leucemia, neuroblastoma), depósito (glucogenosis, Gaucher), hígado graso por obesidad, colestasia.
- Estudio inicial: hemograma con frotis, transaminasas, bilirrubina total y directa, GGT, fosfatasas, albúmina, TP, glicemia; ecografía abdominal.
- Banderas rojas: esplenomegalia asociada, citopenias, ictericia colestásica (acolia, coluria), hipoglicemia, insuficiencia hepática, masa.
- Manejo inicial: tratar causa reconocida (insuficiencia cardíaca, obesidad); corregir coagulopatía con vitamina K.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología/hematooncología según sospecha; colestasia del lactante es urgencia (atresia de vías biliares).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 6 meses es traído por irritabilidad, sudoración y temblor cuando pasa más de 3 a 4 horas sin alimentarse. Al examen tiene facies de muñeca, abdomen prominente y hepatomegalia de 6 cm bajo el reborde costal, sin esplenomegalia. Exámenes en ayuno corto: glicemia 35 mg/dL, lactato elevado, triglicéridos y ácido úrico elevados. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Atresia de vías biliares

B Enfermedad de Gaucher

C Hepatitis viral aguda

D Glucogenosis tipo I

E Hiperinsulinismo congénito

Respuesta D. Hepatomegalia aislada sin esplenomegalia, hipoglicemia de ayuno corto, acidosis láctica, hipertrigliceridemia e hiperuricemia es la glucogenosis tipo I (déficit de glucosa-6-fosfatasa). El hígado no puede liberar glucosa. El hiperinsulinismo da hipoglicemia sin hepatomegalia; Gaucher da esplenomegalia marcada; la atresia biliar cursa con ictericia y acolia.

▶ VER CLASE 2.01.1.045 Insuficiencia hepática aguda

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Gastroenterología 3.2 · Hepatitis Aguda y Crónica

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia hepática aguda: daño hepático agudo con coagulopatía (INR ≥1,5 con encefalopatía o ≥2 sin ella) que no corrige con vitamina K, sin enfermedad hepática previa.
- Causas en niños: hepatitis A, intoxicación por paracetamol, hongos (Amanita), enfermedad de Wilson, autoinmune, metabólicas en lactantes; muchas indeterminadas.
- Clínica: ictericia, vómitos, encefalopatía (puede ser tardía en niños), sangrado, hipoglicemia, ascitis.
- Manejo inicial: hospitalizar, glicemia seriada y aporte de glucosa, vitamina K EV, evitar sedantes, N-acetilcisteína en intoxicación por paracetamol, plasma solo si sangrado o procedimiento.
- Vigilar edema cerebral, hipoglicemia, infecciones, falla renal.
- Seguimiento: derivar precozmente a UCI de centro con trasplante hepático.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 6 años con hepatitis A confirmada hace 8 días presenta mayor ictericia, vómitos persistentes y somnolencia. Exámenes: bilirrubina total 14 mg/dL, GPT 2.800 UI/L, glicemia 58 mg/dL e INR 2,4, que no corrige tras administrar vitamina K. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Hospitalizar y contactar precozmente a un centro con trasplante hepático

B Hospitalizar en sala común y repetir exámenes en 72 horas

C Manejo ambulatorio con reposo y control en una semana

D Iniciar corticoides endovenosos

E Administrar plasma fresco congelado y dar el alta al corregir el INR

Respuesta A. Coagulopatía (INR 2 o más, o 1,5 o más con encefalopatía) que no corrige con vitamina K, en un niño sin hepatopatía previa, define insuficiencia hepática aguda; la hepatitis A es una causa frecuente en Chile. Requiere hospitalización en unidad crítica, manejo de hipoglicemia y encefalopatía, y contacto precoz con un centro de trasplante, porque puede progresar rápidamente.

▶ VER CLASE 2.01.1.046 Displasia broncopulmonar / Reflujo gastroesofágico y vómitos del lactante (código repetido en el Perfil oficial)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Gastroenterología 6.2 · Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño

Pediatría 18.12 · Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal

QUÉ HAY QUE SABER

- Reflujo gastroesofágico fisiológico del lactante: regurgitaciones frecuentes en lactante feliz que crece bien; peak 4 meses, resuelve a los 12-18 meses. No requiere estudio ni fármacos.
- ERGE: reflujo con complicaciones: rechazo alimentario, mal incremento ponderal, irritabilidad, hematemesis, esofagitis, síntomas respiratorios, Sandifer.
- Banderas rojas de otra causa: vómitos biliosos (malrotación), en proyectil (estenosis hipertrófica del píloro, 2-8 semanas, alcalosis metabólica hipoclorémica), fiebre, abombamiento de fontanela, inicio después de los 6 meses.
- Manejo: tranquilizar, fraccionar volúmenes, espesar fórmula, posición vertical post comida (dormir siempre en supino); prueba con fórmula extensamente hidrolizada 2-4 semanas si sospecha APLV.
- Omeprazol 1 mg/kg/día solo en ERGE con esofagitis o síntomas significativos, por tiempo limitado.
- Displasia broncopulmonar: prematuro con requerimiento de O2 a las 36 semanas corregidas; seguimiento de ambas: derivar a gastroenterología o broncopulmonar si complicaciones.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 155

Niño de 28 días con vómitos después de comer, que iniciaron hace una semana y han aumentado en frecuencia e intensidad. La madre refiere que llora después de comer y vomitar, y se objetiva que no ha incrementado bien de peso en el último tiempo, viéndose algo enflaquecido. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?**

A Radiografía baritada de esófago-estómago-duodeno

B Ecografía abdominal

C Endoscopía digestiva alta con biopsia duodenal

D Colonoscopía con biopsia de la pared intestinal

E Radiografía simple toracoabdominal

Respuesta B. Vómitos posprandiales que empiezan hacia las cuatro semanas de vida y van en aumento, con mal incremento de peso: estenosis hipertrófica del píloro. El examen de elección para iniciar el estudio es la ecografía abdominal, que muestra el píloro engrosado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 147

Un lactante está en tratamiento por reflujo gastroesofágico con medicamento en gotas. Presenta un cuadro de trismus, nistagmus, más hiperextensión del cuello. **¿Qué fármaco es más probable que esté recibiendo?**

A Omeprazol

B Cisaprida

C Metoclopramidad

D Domperidona

E Difenhidramina

Respuesta C. Trismus e hiperextensión del cuello en un lactante que recibe un procinético: distonía aguda. La metoclopramida cruza la barrera hematoencefálica y es la que más reacciones extrapiramidales produce; la domperidona casi no la cruza. La difenhidramina es un tratamiento de la distonía, no su causa.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 3 meses con lactancia materna, traído por regurgitaciones después de casi todas las mamadas. Está tranquilo y sonriente, con incremento de peso adecuado y examen físico normal. Los padres, angustiados, piden "algo para el reflujo". **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar omeprazol por 4 semanas

B Solicitar pH-metría esofágica de 24 horas

C Educar y tranquilizar a los padres, con medidas posturales y tomas fraccionadas

D Solicitar ecografía abdominal para descartar estenosis del píloro

E Suspender la lactancia materna e iniciar fórmula antirreflujo

Respuesta C. Lactante feliz que regurgita pero crece bien y tiene examen normal: reflujo fisiológico. Se educa y tranquiliza, se explica que el pico es entre los 2 y 6 meses y que se resuelve hacia el año, con medidas posturales y fraccionamiento. IBP y estudios se reservan para el reflujo patológico.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante varón de 4 semanas, primogénito, con vómitos postprandiales que han ido aumentando en intensidad hasta salir con fuerza, en proyectil. El vómito es de leche cortada, sin color verde. Tras vomitar, llora buscando mamar de nuevo. Su peso está estancado desde el nacimiento. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?**

A pH-metría esofágica de 24 horas

B Ecografía abdominal dirigida al píloro

C Enema baritado con fluoroscopía

D Endoscopía digestiva alta

E Colonoscopía con biopsia

Respuesta B. Varón de 4 semanas con vómitos en proyectil no biliosos, avidez por alimentarse y peso estancado: estenosis hipertrófica del píloro. El examen de elección es la ecografía abdominal, que muestra el músculo pilórico engrosado.

▶ VER CLASE 2.01.1.047 **Síndrome disentérico** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.11 · Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome disentérico: deposiciones con sangre y mucus, pujo, tenesmo, dolor abdominal, fiebre. Agentes: Shigella, Campylobacter, E. coli enteroinvasiva y STEC, Salmonella, E. histolytica.
- Coprocultivo para identificar agente; leucocitos fecales positivos.
- Hidratación según grado de deshidratación con SRO; mantener alimentación.
- Antibiótico en Shigella, compromiso general o <3 meses: azitromicina 10 mg/kg/día por 3-5 días o ceftriaxona EV si grave; ciprofloxacino como alternativa.
- No dar antibiótico ni antidiarreicos si se sospecha E. coli productora de Shiga toxina (O157:H7): aumentan riesgo de síndrome hemolítico urémico.
- Seguimiento: control en 48 h; vigilar palidez, oliguria y petequias en la semana siguiente (SHU): hemograma, función renal y orina.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 47

Un niño de 14 años, con antecedente de síndrome de QT largo con historia familiar positiva, consulta por un cuadro de fiebre, dolor abdominal y deposiciones líquidas de 5 días de evolución, persistentes, que hace 2 días se han vuelto sanguinolentas. **Además de la hidratación, ¿qué antibiótico debe indicarse?**

A Ciprofloxacino
B Azitromicina
C Metronidazol
D Sulfametoxazol con trimetoprim
E Ampicilina

Respuesta D. Un síndrome disentérico febril se trata con antibióticos que cubran Shigella. Ciprofloxacino y azitromicina son opciones habituales, pero prolongan el QT y están contraindicados aquí. El metronidazol no cubre enterobacterias y la ampicilina tiene espectro insuficiente: queda el cotrimoxazol.

▶ VER CLASE 2.01.1.048 Síndrome malabsorción

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 2.3 · Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Malabsorción: diarrea crónica, esteatorrea, distensión, falla de crecimiento, hipoalbuminemia, anemia y déficit de vitaminas liposolubles.
- Enfermedad celíaca: inicio tras introducción del gluten; también talla baja, anemia ferropriva refractaria, hipertransaminasemia. Tamizaje con IgA total y antitransglutaminasa IgA; confirma biopsia duodenal (atrofia vellositaria).
- Otras causas: fibrosis quística (test del sudor), giardiasis, intolerancia a lactosa, APLV, intestino corto.
- Estudio inicial: hemograma, ferritina, albúmina, Sudán III/esteatocrito, parasitológico, sustancias reductoras.
- No retirar el gluten antes de completar el estudio (falsos negativos). Tratamiento celíaca: dieta sin gluten estricta de por vida (TACC).
- Seguimiento: derivar a gastroenterología pediátrica para biopsia y control de anticuerpos y crecimiento.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 120

Una niña de 13 meses ha detenido su crecimiento desde hace 4 meses. Además, presenta deposiciones frecuentes y disgregadas, con tendencia al meteorismo. En sus exámenes destaca anemia ferropénica. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?**

A Anticuerpos IgA antiendomisio
B Cuantificación de inmunoglobulinas
C Test del sudor
D Colonoscopía
E 17-OH-progesterona

Respuesta A. Detención del crecimiento, diarrea crónica, distensión y ferropenia meses después de introducir el gluten sugieren enfermedad celíaca. Se inicia el estudio con serología IgA (antitransglutaminasa o antiendomisio) más IgA total, y se confirma con biopsia duodenal. El test del sudor es para fibrosis quística, que suele dar síntomas respiratorios y esteatorrea desde antes.

▶ VER CLASE 2.01.1.049 Arritmias

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.23 · Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma

QUÉ HAY QUE SABER

- Arritmias pediátricas: la más frecuente sintomática es la taquicardia supraventricular (TPSV): FC >220 lpm en lactante o >180 en niño, QRS estrecho, sin variabilidad, sin onda P visible.
- Arritmia sinusal respiratoria y extrasístoles aisladas en corazón sano son benignas.
- Sospechar: palpitaciones, síncope con ejercicio, irritabilidad y rechazo alimentario en lactante, insuficiencia cardíaca. Pedir ECG de 12 derivaciones.
- TPSV estable: maniobras vagales (hielo en la cara en lactante, Valsalva), luego adenosina 0,1 mg/kg EV rápida (2ª dosis 0,2 mg/kg); inestable: cardioversión sincronizada 0,5-1 J/kg.
- Banderas rojas: síncope con ejercicio, historia familiar de muerte súbita, QT largo, preexcitación (WPW), bloqueo AV completo.
- Seguimiento: derivar a cardiología infantil.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 4 meses es traído por rechazo alimentario, palidez y sudoración. Al examen está soporoso, con llene capilar de 5 segundos, pulsos periféricos débiles y frecuencia cardíaca de 280/min. El monitor muestra una taquicardia regular de QRS estrecho, sin ondas P visibles. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Maniobras vagales con hielo en la cara

B Adenosina en bolo endovenoso rápido como única opción, aunque demore la vía

C Cardioversión eléctrica sincronizada

D Amiodarona oral

E Observar y controlar con ECG en 24 horas

Respuesta C. La taquicardia supraventricular es la arritmia sintomática más frecuente en lactantes (FC habitualmente sobre 220/min, QRS estrecho, sin P). Con signos de shock o compromiso de conciencia es inestable: se trata con cardioversión eléctrica sincronizada (0,5 a 1 J/kg, luego 2 J/kg). Puede usarse adenosina si hay vía venosa inmediata, sin retrasar la cardioversión.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 29

Lactante con FC 280 lpm regular, soporoso, pulsos femorales disminuidos, no se puede medir PA. ¿Cual es la conducta?:

A Cardioversión

B Adenosina

C Maniobras vasovagales (PORQUE NO PUEDE SER ESTA DE MANERA INICIAL???) - pulsos disminuidos se puede interpretar como compromiso HDN... ademas maniobras vagales requieren que el pcte coopere y tenia como 2 años

D Control sano habitual

E Derivar a especialista

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Cardioversión (opción A).

▶ VER CLASE 2.01.1.050 **Cardiopatías congénitas frecuentes** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.21 · Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Cardiopatías congénitas: ~8-10 por 1.000 RN; CIV la más frecuente. Acianóticas con cortocircuito izquierda-derecha: CIV, CIA, ductus, canal AV; obstructivas: coartación, estenosis aórtica/pulmonar.
- Cianóticas: tetralogía de Fallot (la más frecuente después del período neonatal; crisis hipoxémicas), transposición de grandes arterias (la más frecuente en RN, cianosis precoz).
- Sospecha: soplo, cianosis, taquipnea, sudoración y cansancio al alimentarse, mal incremento ponderal, pulsos femorales débiles (coartación), saturación pre-post ductal diferente.
- Tamizaje neonatal con saturometría preductal y postductal (>95% y diferencia ≤3%). Estudio: Rx tórax, ECG, ecocardiograma.
- Manejo inicial: RN cianótico ductus-dependiente: prostaglandina E1; crisis hipoxémica: posición genupectoral, O2, morfina. Cardiopatía congénita operable es GES.
- Seguimiento: derivar a cardiología infantil; profilaxis de endocarditis cuando corresponde y vacunas completas.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 162

Una niña de 7 meses, con antecedente de síndrome de Down, ha tenido un mal incremento ponderal y aún no duplica su peso de nacimiento. Se cansa al alimentarse y ha presentado varias infecciones respiratorias. Al examen físico se palpa frémito en el precordio izquierdo y se ausculta un soplo holosistólico en el mesocardio, con segundo ruido desdoblado. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Coartación aórtica

B Comunicación interauricular

C Canal auriculoventricular completo

D Comunicación interventricular

E Ductus arterioso persistente

Respuesta C. El síndrome de Down se asocia típicamente al canal auriculoventricular. La clínica mezcla un componente interventricular (soplo holosistólico con frémito) y uno interauricular (segundo ruido desdoblado), con insuficiencia cardíaca por hiperflujo: mal incremento, cansancio al comer e infecciones respiratorias.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 62

Un recién nacido de término, presenta cianosis desde su nacimiento, con saturación arterial de 65% con aporte de oxígeno al 100%. Al examen físico destaca murmullo pulmonar disminuido en ambos campos pulmonares, soplo sistólico y pulsos presentes. Como parte de su estudio se solicita radiografía de tórax que muestra cargiomegalia y mediastino delgado. El diagnóstico más probable es:

A Trasposición de grandes vasos
B Comunicación interauricular
C Coartación aórtica
D Canal auriculoventricular
E Comunicación interventricular

Respuesta A. Si bien suele no tener soplos, la TGV es la única opción que muestra una cardiopatía cianótica. Además sí tiene el mediastino delgado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 33

Niño con mal incremento pondoestatural, se cansa al alimentarse y presenta soplo holosistólico III en mesocardio. ¿Diagnóstico más probable?

A Estenosis pulmonar
B Comunicación interauricular
C Tetralogía de Fallot
D Comunicación interventricular
E Coartación de aorta

Respuesta D. Diagnóstico: Comunicación interventricular (opción D). Comunicación interventricular. Las cardiopatías congénitas son defectos estructurales del corazón presentes desde el nacimiento.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 111

Usted controla a una niña de 7 meses de edad, con antecedente de síndrome de Down, con infecciones respiratorias en múltiples ocasiones que han requerido hospita- lización y que aún no ha podido duplicar el peso de nacimiento. Al examen físico se ausculta ritmo regular en dos tonos, con soplo holosistólico intenso, irradiado a dorso, asociado a un desdoblamiento del segundo ruido. El diagnóstico más probable es:

A Comunicación interauricular tipo ostium secundum
B Canal auriculoventricular
C Atresia tricuspidea
D Ductus arterioso persistente
E Comunicación interventricular

Respuesta B. Diagnóstico: Canal auriculoventricular (opción B). Es un CAV clásico. Las cardiopatías congénitas son defectos estructurales del corazón presentes desde el nacimiento.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 138

Un recién nacido presenta un soplo pansistólico, que se escucha entre el tercer y cuarto espacio intercostal. Además presenta algunas crepitaciones escasas en ambos campos pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Comunicación interauricular
B Comunicación interventricular
C Ductus arterioso persistente
D Estenosis mitral
E Atresia tricuspidea

Respuesta B. Diagnóstico: Comunicación interventricular (opción B). Es una CIV clásica. Las cardiopatías congénitas son defectos estructurales del corazón presentes desde el nacimiento.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 89

Un niño de 8 años acude a consulta por dificultad para seguir el ritmo en actividades físicas en la escuela. No tiene antecedentes médicos relevantes, salvo infecciones respiratorias recurrentes en los últimos años. Sus signos vitales son normales, al igual que su auscultación pulmonar. A la auscultación cardiaca, se detecta un soplo continuo de intensidad III/VI en la región paraesternal e infraclavicular izquierda. El niño presenta una talla de -1 desviaciones estándar para su edad y un peso adecuado para su talla. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Miocardiopatía hipertrófica
B Comunicación interventricular
C Comunicación interauricular
D Ductus arterioso persistente
E Soplo funcional

Respuesta D. Ductus Arterioso Persistente: El soplo continuo es característico del ductus arterioso persistente. Se recomienda revisar el resumen de semiología cardíaca.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 39

Un recién nacido presenta, a los pocos minutos de nacer, cianosis generalizada, con saturación de 65%. En su examen físico, se ausculta un soplo sistólico eyectivo II/VI paraesternal. Su radiografía de tórax muestra campos pulmonares sin alteraciones, hilios de tamaño normal, recesos costodiafragmáticos libres y mediastino delgado ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Canal auriculoventricular completo

B Coartación aórtica

C Comunicación interventricular grande

D Transposición de grandes arterias

E Cardiopatía hipertrófica

Respuesta D. Revisar el resumen de semiología cardíaca. Si bien la TGV no suele tener soplos, sí puede tenerlo, ya que la arteria pulmonar queda algo estrecha para la sangre que proviene del ventrículo izquierdo y eso produce flujo turbulento. Además, la TGV es la única cardiopatía cianótica de las alternativas y, por ello, es la respuesta correcta con certeza. La TGV sí se caracteriza por un mediastino delgado.

▶ VER CLASE 2.01.1.051 Endocarditis infecciosa

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.23 · Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma

QUÉ HAY QUE SABER

- Endocarditis infecciosa pediátrica: principalmente en cardiopatías congénitas (operadas o no) y portadores de catéter venoso central.
- Agentes: Streptococcus viridans y S. aureus; HACEK y hongos menos frecuentes.
- Sospechar: fiebre prolongada en paciente con cardiopatía, soplo nuevo o cambiante, esplenomegalia, fenómenos embólicos, hematuria, petequias, nódulos de Osler, lesiones de Janeway.
- Diagnóstico con criterios de Duke: hemocultivos (3 sets antes de antibiótico) y ecocardiograma (vegetaciones).
- Manejo inicial: hospitalizar, tomar hemocultivos antes de iniciar antibiótico empírico EV (penicilina/ampicilina + gentamicina, cloxacilina si S. aureus), por 4-6 semanas.
- Prevención: profilaxis con amoxicilina 50 mg/kg 30-60 min antes de procedimientos dentales en cardiopatías de alto riesgo. Seguimiento: derivar a cardiología e infectología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 9 años con antecedente de comunicación interventricular no operada presenta fiebre de 2 semanas, decaimiento y baja de peso. Hace un mes se realizó una extracción dental. Al examen tiene soplo holosistólico de mayor intensidad que en controles previos, esplenomegalia leve y hemorragias en astilla subungueales. **¿Cuál es el examen más importante para iniciar el estudio?**

A Electrocardiograma

B Proteína C reactiva

C Radiografía de tórax

D Serología para Bartonella

E Hemocultivos seriados antes de iniciar antibióticos

Respuesta E. Fiebre prolongada en un niño con cardiopatía congénita, con soplo que cambia, esplenomegalia y fenómenos vasculares, sugiere endocarditis infecciosa (criterios de Duke). Lo fundamental es obtener 3 hemocultivos de punciones separadas antes de los antibióticos, y luego ecocardiograma. Los agentes más frecuentes son estreptococos del grupo viridans y Staphylococcus aureus.

▶ VER CLASE 2.01.1.052 Insuficiencia cardíaca

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.23 · Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia cardíaca en lactantes: taquipnea, sudoración y fatiga al alimentarse, mal incremento ponderal, taquicardia, hepatomegalia, ritmo de galope; edema periférico es raro.
- Causas: cardiopatías con cortocircuito izquierda-derecha (CIV grande, ductus, canal AV) en lactantes; miocarditis y miocardiopatías en mayores; también arritmias y anemia grave.
- Estudio: Rx tórax (cardiomegalia, congestión), ECG, ecocardiograma, BNP, gases y electrolitos.
- Manejo inicial: O2, posición semisentada, furosemida 1 mg/kg EV/VO, restricción hídrica moderada, aumentar densidad calórica de la alimentación; IECA (captopril) por especialista.
- Shock cardiogénico: evitar sobrecarga de volumen, apoyo inotrópico (milrinona, dobutamina) en UCI.
- Seguimiento: derivar a cardiología infantil.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 173

Lactante de 4 meses de edad, sin antecedentes conocidos, alimentado con lactancia materna exclusiva, es traído por bajo incremento ponderal, asociado a cansancio al alimentarse y decaimiento. Se aprecia decaído, con saturación arterial de 90%, examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos y soplo sistólico, y examen pulmonar con murmullo disminuido en bases y crepitaciones finas bilaterales. **¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A Administrar furosemida endovenosa

B Administrar vasodilatadores endovenosos

C Administrar epinefrina endovenosa

D Realizar intubación endotraqueal y ventilación mecánica

E Administrar betabloqueadores endovenosos

Respuesta A. Cansancio al alimentarse, mal incremento ponderal, soplo y crepitaciones en un lactante sugieren insuficiencia cardíaca por cortocircuito izquierda-derecha (ej. CIV) con congestión pulmonar. El manejo inicial es diurético (furosemida) y oxígeno, y luego ecocardiograma. Los vasodilatadores pueden aumentar el cortocircuito y el paciente no tiene criterios de intubación.

▶ VER CLASE 2.01.1.053 Síncope

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.10 · Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Síncope: pérdida transitoria de conciencia y tono con recuperación espontánea completa. Vasovagal es el más frecuente en adolescentes: pródromo (calor, náuseas, visión borrosa), gatillado por estar de pie, dolor o emoción.
- Evaluación: anamnesis, examen cardiovascular, presión ortostática y ECG de 12 derivaciones en todos (buscar QT largo, WPW, Brugada, bloqueo, HVI).
- Banderas rojas de síncope cardíaco: durante el ejercicio, en decúbito, precedido de palpitaciones, sin pródromo, con lesiones, historia familiar de muerte súbita <40 años, soplo patológico.
- Diferencial: crisis epiléptica (movimientos prolongados, confusión postictal), hipoglicemia, espasmo del sollozo en lactantes.
- Manejo del vasovagal: educación, ingesta de agua y sal, maniobras de contrapresión, evitar gatillantes.
- Seguimiento: derivar a cardiología si hay banderas rojas o ECG alterado; vasovagal típico se controla en APS.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una adolescente de 14 años, sana, presentó pérdida de conciencia de 20 segundos mientras estaba de pie en un acto escolar con calor. Antes sintió náuseas, calor, visión borrosa y palidez; tras caer se recuperó completamente en segundos, sin confusión. No tiene antecedentes familiares de muerte súbita. Su examen cardiovascular y neurológico y el electrocardiograma son normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar electroencefalograma

B Solicitar TAC de cerebro

C Solicitar Holter de ritmo y ecocardiograma

D Educar sobre síncope vasovagal: hidratación y maniobras de contrapresión

E Iniciar ácido valproico

Respuesta D. Pérdida de conciencia breve, con gatillante (bipedestación prolongada, calor), pródromo autonómico y recuperación rápida sin período postictal, con examen y ECG normales, es un síncope vasovagal, la causa más frecuente en adolescentes. Se maneja con educación, hidratación, sal y maniobras de contrapresión.

▶ VER CLASE 2.01.1.054 Soplos

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.23 · Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma

QUÉ HAY QUE SABER

- Soplo inocente: muy frecuente (hasta 50% de niños), sistólico, suave (grado ≤2/6), corto, en borde esternal izquierdo, varía con la posición, sin frémito, con examen y desarrollo normales (soplo de Still, zumbido venoso).
- Soplo patológico: diastólico, holosistólico, grado ≥3/6 con frémito, segundo ruido alterado (desdoblamiento fijo en CIA), clic, asociado a síntomas.
- Banderas rojas: cianosis, pulsos femorales disminuidos (coartación), taquipnea, mal incremento ponderal, sudoración al alimentarse, síncope, RN con soplo.
- Estudio: saturometría, presión en 4 extremidades, ECG y Rx tórax; ecocardiograma confirma.
- Soplo inocente no requiere exámenes ni restricción; tranquilizar a la familia.
- Seguimiento: derivar a cardiología infantil todo soplo sospechoso, todo soplo en RN o lactante con síntomas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 154

Un niño de 13 años acude a control médico por una infección respiratoria alta. En su examen físico se ausculta un soplo paraesternal izquierdo, sistólico, de intensidad II/VI, sin otras alteraciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Soplo inocente
B Ductus arterioso persistente
C Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
D Estenosis aórtica
E Coartación aórtica

Respuesta A. Un soplo sistólico suave (grado II/VI o menor), paraesternal izquierdo, en un niño asintomático y en contexto febril o infeccioso (estado hiperdinámico), sin otros hallazgos, es un soplo inocente. Signos de soplo patológico: diastólico, holosistólico, grado III o más, frémito, clic, síntomas o pulsos alterados. El ductus da un soplo continuo.

▶ VER CLASE 2.01.1.055 Alergias

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.8 · Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Urticaria aguda: ronchas pruriginosas evanescentes (<24 h cada lesión); en niños la causa más frecuente es infección viral, luego alimentos y fármacos. Antihistamínico 2ª generación (cetirizina, loratadina) por 1-2 semanas.
- Anafilaxia: compromiso cutáneo con respiratorio, cardiovascular o digestivo tras exposición; adrenalina IM 0,01 mg/kg (1 mg/ml) en cara anterolateral del muslo, máx 0,3 mg (niño) y 0,5 mg (adolescente), repetir c/5-15 min.
- Alergia a proteína de leche de vaca: lactante con proctocolitis (sangre en deposiciones), vómitos, eccema; dieta de exclusión materna o fórmula extensamente hidrolizada (aminoácidos si grave) y reintroducir tras 6-12 meses.
- Alergias alimentarias más frecuentes: leche, huevo, maní, frutos secos, pescado, mariscos; diagnóstico con historia, IgE específica o prick test y prueba de provocación.
- Educación: plan de acción escrito, autoinyector de adrenalina en anafilaxia, lectura de etiquetados.
- Seguimiento: control en APS; derivar a inmunología/alergia si anafilaxia, alergias múltiples o persistentes.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 178

Niño con rash urticarial, edema de labios, taquicardia y sensibilidad abdominal. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A Adrenalina intramuscular
B Difenhidramina endovenosa
C Hidrocortisona endovenosa
D Clorfenamina oral
E Salbutamol inhalado

Respuesta A. Rash urticarial más angioedema de labios, taquicardia y dolor abdominal: son criterios de anafilaxia, con compromiso hemodinámico y digestivo asociado. El tratamiento inicial inmediato es siempre la adrenalina intramuscular, no los antihistamínicos ni los corticoides.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 91

Lactante de 2 meses con diarrea, vómitos y dermatitis perioral y perianal tras la introducción de fórmula láctea. El test de parche resulta positivo para proteína de leche de vaca. **¿Cuál es el manejo?**

A Cambiar a fórmula extensamente hidrolizada o elemental
B Continuar la fórmula habitual y agregar antihistamínico
C Hospitalizar para estudio endoscópico
D Iniciar corticoides orales
E Cambiar a leche de soja

Respuesta A. Diarrea y vómitos, más dermatitis, tras introducir fórmula láctea: alergia a la proteína de leche de vaca. El tratamiento es retirar la proteína, con una fórmula extensamente hidrolizada o elemental. La leche de soja no se recomienda antes de los seis meses, por reactividad cruzada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 34

Un niño de 4 años presenta ronchas evanescentes en el tronco y las extremidades desde hace 4 días. Además, desde hace algunos días presentaba congestión nasal, con coriza y estornudos. Al examen físico se observan habones en el tórax y dermografismo en las extremidades inferiores. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar corticoides orales
B Solicitar prick test
C Indicar antihistamínicos orales
D Solicitar IgE sérica total
E Solicitar test de parches

Respuesta C. Habones evanescentes de pocos días en un niño con un cuadro viral reciente corresponden a urticaria aguda, cuya causa más frecuente en pediatría son las infecciones virales. El tratamiento es antihistamínico H1 oral de segunda generación (ej. cetirizina). No requiere estudio alérgico; los corticoides quedan para casos graves o refractarios.

▶ VER CLASE 2.01.1.056 Inmunodeficiencias

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.25 · Inmunodeficiencias Primarias, Infecciones Recurrentes, Hepatomegalia e Interpretación del Hemograma Pediátrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Inmunodeficiencias primarias: sospechar con infecciones recurrentes graves, por gérmenes oportunistas o de localización inusual, falla de crecimiento, historia familiar.
- Humoral (la más frecuente, ej. déficit IgA, agammaglobulinemia de Bruton): infecciones sinopulmonares por bacterias encapsuladas después de los 6 meses.
- Celular/combinada (inmunodeficiencia combinada grave): infecciones virales, fúngicas, Pneumocystis, diarrea crónica y desmedro desde los primeros meses; linfopenia.
- Fagocítica (enfermedad granulomatosa crónica): abscesos por S. aureus y hongos; complemento: infecciones por Neisseria recurrentes. Caída tardía del cordón: defecto de adhesión leucocitaria.
- Estudio inicial: hemograma con recuento absoluto de linfocitos, inmunoglobulinas, VIH; no administrar vacunas vivas (BCG, rotavirus, SRP, varicela) si sospecha de déficit celular.
- Seguimiento: derivar a inmunología pediátrica.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 136

Un lactante de 15 meses fue sano hasta los 6 meses de edad, pero desde entonces ha presentado candidiasis oral a repetición, cuatro otitis medias agudas y dos neumonías que han requerido hospitalización. **¿Cuál es la causa más probable de su inmunodepresión?**

A Inmunodeficiencia humoral
B Inmunodeficiencia combinada severa
C Alteración de la fagocitosis
D Déficit de complemento
E Inmunodeficiencia celular

Respuesta A. Infecciones bacterianas sinopulmonares recurrentes (otitis, neumonías) que comienzan después de los 6 meses, cuando desaparece la IgG materna transferida, sugieren una inmunodeficiencia humoral (ej. agammaglobulinemia ligada al X). La inmunodeficiencia combinada severa se manifiesta desde los primeros meses con infecciones oportunistas graves y falla de crecimiento. Se estudia con cuantificación de inmunoglobulinas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 12

Niño que después de los 6 meses presenta candidiasis bucal, otitis media recurrente y 2 neumonías hospitalizadas. ¿Cuál es la inmunodeficiencia más probable?

A Inmunodeficiencia celular (DiGeorge)
B Déficit de complemento
C Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia)
D Inmunodeficiencia combinada severa (SCID)
E Enfermedad granulomatosa crónica

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia)). Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia). Prevención de transmisión vertical (madre VIH+): 1.

▶ VER CLASE 2.01.1.057 Mesenquimopatías

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.13 · Miopatías Inflamatorias Autoinmunes: Polimiositis, Dermatomiositis y Tamizaje de Cáncer Oculto

QUÉ HAY QUE SABER

- Mesenquimopatías pediátricas: lupus eritematoso sistémico (adolescentes mujeres), dermatomiositis juvenil, esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo.
- LES: eritema malar, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, serositis, nefritis (proteinuria, hematuria), citopenias, compromiso neurológico; más grave en niños que en adultos.

- Dermatomiositis juvenil: debilidad muscular proximal simétrica, heliotropo, pápulas de Gottron, CK elevada.
- Estudio inicial: hemograma, VHS, PCR, función renal, orina completa, ANA; anti-DNA y complemento (C3, C4 bajos en LES activo), CK.
- Manejo inicial: AINE para artritis, fotoprotección; corticoides e inmunosupresores los indica el especialista.
- Seguimiento: derivar a reumatología pediátrica; urgencia si compromiso renal o neurológico.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 163

Un niño de 12 años consulta por cansancio, artralgias, dolores musculares generalizados y fiebre. Refiere que las mialgias son intensas, al punto que limitan su actividad física. Al examen físico presenta dolor a la palpación de las masas musculares, en especial en la espalda alta y los hombros. Además, tiene eritema violáceo en los párpados superiores. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Artritis reumatoide juvenil
B Distrofia muscular
C Dermatomiositis
D Triquinosis
E Lupus infantil

Respuesta C. Debilidad y dolor muscular proximal con eritema heliotropo (violáceo palpebral) es dermatomiositis; en niños es la miopatía inflamatoria más frecuente. Se apoya con CK elevada, resonancia o biopsia muscular. A diferencia del adulto, la forma juvenil no se asocia a cáncer, pero sí a calcinosis y vasculopatía. La triquinosis da edema palpebral, no eritema heliotropo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 78

Escolar femenina de 12 años con artritis en múltiples articulaciones, fotosensibilidad, úlceras orales, proteinuria 4 g/24h, hematuria microscópica y ANA positivo 1:640. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Lupus eritematoso sistémico
B Artritis idiopática juvenil
C Dermatomiositis juvenil
D Vasculitis sistémica
E Enfermedad de Kawasaki

Respuesta A. LES: artritis + fotosensibilidad + úlceras orales + nefritis lúpica (proteinuria >3.5g + hematuria) + ANA positivo en patrón homogéneo. Cumple criterios SLICC para diagnóstico.

▶ VER CLASE 2.01.1.058 Vasculitis: PSH, Kawasaki, otros

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Infectología 5.3 · Exantemas Febriles de la Infancia: Sarampión, Rubéola, Escarlatina y Kawasaki
Pediatría 18.10 · Exantemas Infantiles: Diagnóstico Diferencial (Eritema Infeccioso, Exantema Súbito, Escarlatina, Varicela y Kawasaki)
Reumatología 9.22 · Vasculitis de Vaso Pequeño ANCA Positivas (GPA, PAM, EGPA) y Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA)

QUÉ HAY QUE SABER

- Púrpura de Schönlein-Henoch (vasculitis IgA): la más frecuente en niños; púrpura palpable en extremidades inferiores y glúteos con plaquetas normales, artritis/artralgias, dolor abdominal y nefritis.
- PSH manejo: reposo, analgesia (paracetamol, AINE si función renal normal); prednisona si dolor abdominal intenso. Complicación: invaginación intestinal, nefropatía. Orina completa y PA seriadas por 6 meses.
- Enfermedad de Kawasaki: fiebre ≥5 días + ≥4 de 5: conjuntivitis bilateral no purulenta, cambios en labios/mucosa oral (lengua aframbuesada), exantema polimorfo, cambios en extremidades (edema, descamación periungueal), adenopatía cervical >1,5 cm.
- Kawasaki: inmunoglobulina 2 g/kg EV en 12 h + aspirina en dosis altas y luego bajas; idealmente en los primeros 10 días para prevenir aneurismas coronarios. Ecocardiograma al diagnóstico y a las 2 y 6 semanas.
- Kawasaki incompleto: fiebre ≥5 días con <4 criterios y laboratorio compatible (PCR alta, trombocitosis, anemia, piuria estéril).
- Seguimiento: derivar Kawasaki a hospital/cardiología; PSH con nefritis (proteinuria importante, HTA, falla renal) a nefrología.

PREGUNTAS · 17

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 11

Niño de 8 años con fiebre de 39°C por 7 días de evolución, exantema polimorfo, adenopatías cervicales, conjuntivitis bilateral no exudativa y lengua en fresa. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Enfermedad de Kawasaki
B Mononucleosis infecciosa
C Escarlatina
D Artritis idiopática juvenil
E Sarampión

Respuesta A. Fiebre ≥ 5 días + 4 criterios (exantema polimorfo, adenopatía cervical, conjuntivitis no exudativa, lengua en fresa): enfermedad de Kawasaki. Requiere ecocardiograma e IGEV + aspirina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 12

Un niño de 3 años presenta un cuadro de 6 días de evolución de fiebre hasta 39,2°C, asociado a malestar general y aparición de un rash eritematoso en tronco y extremidades. Al examen físico está decaído y febril a 38,7°C, se objetiva la presencia del rash descrito y se palpan adenopatías en la cadena cervical anterior e induración de la cicatriz de la vacuna BCG. **Además de solicitar hemograma, VHS y PCR, el examen de elección para continuar el estudio es:**

A Títulos de anticuerpos antiestreptolisina O

B Procalcitonina

C PCR para Mycobacterium tuberculosis

D Ecocardiograma

E Serología para virus de Epstein Barr

Respuesta D. Fiebre ≥ 5 días con exantema y adenopatía cervical en un preescolar: sospecha de enfermedad de Kawasaki. El examen clave es el ecocardiograma, para buscar aneurismas coronarios, que determinan el pronóstico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 75

Un niño de 2 años presenta un cuadro de 7 días de fiebre hasta 39 grados, asociado a inyección conjuntival y boca roja con labios partidos, a lo que se agrega un exantema eritematoso generalizado. Al examen, se aprecia decaído, con fiebre de 38,8 grados, presenta adenopatías cervicales y se observa descamación gruesa de los dedos de las 4 extremidades. Se encuentra hospitalizado, recibiendo un tratamiento adecuado. **¿Cuál es la evolución más probable en este paciente?**

A Daño permanente de las arterias coronarias

B Recurrencia esporádica de los síntomas

C Resolución completa, sin secuelas

D Daño vascular periférico generalizado

E Daño a las válvulas cardíacas

Respuesta C. Enfermedad de Kawasaki tratada adecuadamente (IGEV + aspirina): el riesgo de aneurismas baja de 25% a menos de 3–5%, por lo que lo más probable es la resolución completa sin secuelas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM · DIAGNÓSTICO DE PÚRPURA DE HENOCH-SCHÖNLEIN

Niño de 7 años consulta por dolor abdominal cólico difuso, dolor en ambos tobillos y una erupción cutánea purulenta violácea sobreelevada en ambas extremidades inferiores y nalgas, de 4 días de evolución tras un cuadro de resfrío común. Al examen físico destaca abdomen blando pero doloroso a la palpación difusa sin peritonismo, rodillas y tobillos con aumento de volumen periarticular doloroso y púrpura palpable bilateral confluente en piernas. El hemograma muestra: hematocrito 38%, leucocitos 9.800/mm³, plaquetas 310.000/mm³. El examen de orina revela microhematuria (15 hematíes por campo) sin proteinuria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el pilar del manejo inicial?

A Púrpura Trombocitopénico Inmune (PTI) · Inmunoglobulina endovenosa urgente

B Meningococcemia fulminante · Ceftriaxona EV inmediata y aislamiento respiratorio

C Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA) · Reposo, analgesia con paracetamol y monitorización ambulatoria estrecha de PA y orina

D Síndrome Urémico Hemolítico · Transfusión urgente de plaquetas y plasmaféresis

E Lupus eritematoso sistémico pediátrico · Ciclofosfamida endovenosa inmediata

Respuesta C. El cuadro clínico de púrpura palpable en extremidades inferiores y glúteos, artralgias/artritis y dolor abdominal cólico postinfeccioso con un recuento plaquetario rigurosamente normal (310.000/mm³) configura la tétrada diagnóstica del Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculitis por IgA). En ausencia de dolor abdominal intratable, sangrado digestivo o nefritis severa, el curso es típicamente benigno y autolimitado, requiriendo reposo, analgesia con paracetamol y vigilancia seriada de presión...

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 3 años con fiebre de 39,5 °C de 6 días que no cede con paracetamol ni ibuprofeno. Tiene inyección conjuntival bilateral intensa sin secreción, labios eritematosos secos con fisuras sangrantes, lengua aframbuesada, exantema maculopapular en tronco y edema duro con eritema en palmas y plantas. Ganglio cervical derecho único de 2 cm, no fluctuante. El ecocardiograma inicial no muestra alteraciones coronarias. **¿Cuál es la conducta terapéutica inmediata?**

A Amoxicilina oral 50 mg/kg/día por 10 días

B Inmunoglobulina endovenosa 2 g/kg en infusión única + aspirina

C Corticoides orales y control ambulatorio

D Observación, ya que el ecocardiograma es normal

E Vitamina A oral y notificación inmediata

Respuesta B. Fiebre ≥ 5 días + 5 de 5 criterios (conjuntivitis no exudativa, cambios orales, edema palmoplantar, exantema polimorfo, adenopatía cervical unilateral ≥ 1,5 cm): enfermedad de Kawasaki. IGEV 2 g/kg en infusión única + aspirina 30–50 mg/kg/día, antes del día 10 de fiebre, para prevenir los aneurismas coronarios. Un ecocardiograma inicial normal no permite observar.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niña de 3 años, con fiebre de 39,5 °C durante 6 días, decaída. Al examen: inyección conjuntival bilateral sin secreción, labios agrietados y sangrantes, lengua roja con papilas marcadas, exantema polimorfo en el tronco, y edema doloroso de manos y pies. No hay adenopatías palpables. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Amoxicilina oral por 10 días, sospechando escarlatina

B Inmunoglobulina endovenosa más ácido acetilsalicílico, y ecocardiograma

C Observación domiciliaria, porque falta la adenopatía cervical

D Aciclovir oral, sospechando varicela atípica

E Antihistamínicos, sospechando una reacción alérgica

Respuesta B. Fiebre de 5 días o más (aquí 6) más 4 de los 5 criterios (ojos, boca, exantema, extremidades; falta solo la adenopatía) confirma Kawasaki. No necesitas los 5 criterios, basta con 4. El tratamiento urgente es inmunoglobulina más aspirina, con ecocardiograma para vigilar las coronarias.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 128

Un prescolar de 2 años, presenta un cuadro de fiebre alta, desde hace 5 días, asociado marcado decaimiento. Al examen físico presenta un exantema eritematoso en el tronco, asociado a eritema de las manos y ojo rojo. La boca muestra amígdalas congestivas y lengua enrojecida. El diagnóstico más probable es:

A Síndrome pie mano boca

B Eritema infeccioso

C Escarlatina

D Sarampión

E Enfermedad de Kawasaki

Respuesta E. Diagnóstico: Enfermedad de Kawasaki (opción E). Es una enfermedad de Kawasaki clásica. El ojo rojo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica del médico general.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 53

Un niño de 8 años de edad presenta un cuadro de aparición de lesiones eritematosas en las extremidades inferiores y en los glúteos, asociado a dolor en ambos tobillos, a lo que luego se agrega dolor abdominal y vómitos. Al examen presenta lesiones eritematosas solevantadas en las zonas descritas, aumento de volumen en ambos tobillos y dolor abdominal difuso a la palpación. ¿Qué examen es más adecuado para definir el pronóstico de esta enfermedad?

A Hemograma

B Sedimento de orina

C LDH

D Perfil bioquímico

E VHS

Respuesta B. Es un púrpura de Schönlein Henoch, cuyo pronóstico depende principalmente de la afectación renal. Se pide un sedimento de orina para determinar si hay glomerulonefritis y también creatinina para ver s hay insuficiencia renal y luego se sigue con examen de orina completa (muestra la hematuria y la proteinuria que pueden persistir, deteriorando el pronóstico).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 120

Niño con lesiones eritematosas en miembros inferiores (foto) con artralgias de tobillos de 2 días de evolución y dolor abdominal. Al examen físico presenta edema de ambos tobillos, con lesiones en las piernas, como las que se muestran en la siguiente imagen: Considerando las complicaciones frecuentes del cuadro, es importante solicitar:

A Creatininemia

B Hematocrito

C Plaquetas

D Protombinemia

E Proteina C reactiva

Respuesta A. Es un púrpura de Schönlein Henoch, que se complica con glomerulonefritis e Insuficiencia renal. Es normal que se pregunte varias veces lo mismo en el Eunacom.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 21

Lactante 2 meses, cuadro de 7 días de fiebre, adenopatías, inyección conjuntival. a. Kawasaki

A Control sano habitual

B Derivar a especialista

C Hospitalizar

D Observación domiciliaria

E Iniciar tratamiento empírico

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Control sano habitual).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 126

Un escolar de 8 años consulta por aparición de lesiones en las extremidades infe- riores, consistentes en pápulas eritematosas, palpables. Refiere además artralgias mi- gratorias en las manos, rodillas y codos, y también hematoquezia en algunas oportuni- dades desde hace algunos días ¿Cuál es la complicación más probable en el mediano plazo?

A Aneurismas coronarios
B Infartos cerebrales
C Hepatitis
D Daño vascular periférico
E Nefritis

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Nefritis). Es un púrpura de Schönlein Henoch, que suele producir glomerulonefritis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 30

Un niño de 7 años es traído por su madre por un cuadro de una semana de evolución de aparición de lesiones eritematosas en ambas extremidades inferiores, a lo que se agregó dolor y edema en los tobillos. Al examen físico, se observa aumento de volumen en ambos tobillos, doloroso a la palpación. Se solicita hemograma, que resulta normal, al igual que el examen de orina completa y los niveles plasmáticos de creatinina. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A Prednisona
B Paracetamol
C Gammaglobulina endovenosa
D Ibuprofeno
E Colchicina

Respuesta A. Púrpura de Schönlein-Henoch con complicaciones: El cuadro clínico sugiere una púrpura de Schönlein-Henoch, que generalmente se observa. Sin embargo, en presencia de complicaciones como falla renal, artritis o dolor abdominal, se recomienda el manejo con corticoides orales, específicamente prednisona.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 17

Niño con fiebre de 7 días, ojo rojo, lengua roja, adenopatías cervicales y exantema maculopapular. ¿Cuál es la complicación más probable?

A Artritis reactiva
B Miocarditis aguda
C Aneurismas coronarios
D Meningitis aséptica
E Uveítis anterior

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Aneurismas coronarios). Aneurismas coronarios. El ojo rojo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica del médico general.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 49

Un niño de 5 años presenta un cuadro de 7 días con fiebre alta, que no ha respondido al uso de antipiréticos, alcanzado peaks febriles de hasta 39°C. Al examen físico tiene T°: 38,6°C, pulso regular a 110x', inyección conjuntival bilateral, lengua muy enrojecida, faringe eritematosa, cuello con adenopatías submandibulares y presencia de un exantema eritematoso en el tronco y la zona genital. ¿Cuál es la complicación más probable?

A Glomerulonefritis
B Pericarditis
C Hepatitis
D Rotura esplénica
E Aneurisma coronario

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Aneurisma coronario).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 26

Un niño presenta aparición de lesiones eritematosas en las extremidades inferiores, hace 7 días, las que se muestran más abajo, a lo que se ha agregado edema de ambos tobillos. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para identificar una complicación frecuente de esta patología?

A Creatininemia
B Coronariografía
C Recuento de plaquetas
D Radiografía de pelvis
E Velocidad de eritrosedimentacón

Respuesta A. Es una púrpura de Schönlein Henoch y su complicación más importante y que marca el pronóstico es la GNA con la consecuente falla renal. De hecho, no solo se pide la creatinina, sino también sedimento y proteinuria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 60

Un niño de 4 años presenta un cuadro de 2 días de evolución de aparición de múltiples lesiones eritematosas en las extremidades inferiores, palpables, asociado a dolor abdominal difuso y dolor de ambos tobillos. Al examen físico se palpa abdomen blando, depresible, doloroso leve, de manera difusa, sin signos peritoneales y los tobillos se aprecian aumentados de volumen, con dolor a la movilización. ¿Qué examen es más adecuado para definir el pronóstico de la enfermedad descrita?

A Perfil bioquímico
B Biopsia de médula ósea
C Hemograma
D Sedimento de orina
E LDH

Respuesta D. Es un púrpura de Schönlein Henoch, que se complica con glomerulonefritis. El compromiso renal marca el pronóstico. De hecho, luego se sigue con orina completa (para ver la proteinuria y la hematuria).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 135

Un paciente de 17 años consulta por aparición de lesiones en las extremidades inferiores. Al interrogatorio, refiere que desde hace 5 días presenta dolor abdominal asociado a deposiciones diarreicas con estrías de sangre y que ha notado aumento de volumen en ambos tobillos. Hace un día nota aparición de lesiones eritematosas en ambas piernas que han aumentado de tamaño y cantidad. Al examen físico se observan petequias y pápulas violáceas palpables en ambas piernas y zona glútea. Entre sus exámenes destaca hemograma con hematocrito: 42%, hemoglobina: 13,1 g/dL, glóbulos blancos: 8.400/mm³ y plaquetas: 200.000/mm³. Refiere que ha tomado antiinflamatorios para el manejo del dolor abdominal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Enfermedad de Kawasaki
B Púrpura trombocitopénica inmune
C Eritema nodoso
D Púrpura de Schönlein-Henoch
E Reacción a fármacos

Respuesta D. Es una Púrpura de Schönlein-Henoch clásica. Suele tener hemograma normal (no es trombocitopénica). Sus síntomas más frecuentes son 4: púrpura palpable de extremidades inferiores (puede afectar glúteos y extremidades superiores), compromiso renal (glomerulonefritis, hematuria, falla renal), compromiso gastrointestinal (dolor abdominal, hematoquecia) y compromiso articular (artralgias y artritis).

▶ VER CLASE 2.01.1.059 Enuresis

DX ESPECÍFICO · TX COMPLETO · SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.27 · Uroginecología Pediátrica: Fimosis, Sinequias Vulvares y Enuresis

QUÉ HAY QUE SABER

- Enuresis: micción involuntaria durante el sueño en ≥5 años, ≥1 vez/semana por ≥3 meses. Primaria (nunca controló, la más frecuente) o secundaria (tras ≥6 meses seco).
- Monosintomática: sin síntomas diurnos; mecanismo poliuria nocturna, baja capacidad vesical y alto umbral de despertar; fuerte componente familiar; resolución espontánea ~15%/año.
- Evaluación: anamnesis (hábitos, síntomas diurnos, constipación), examen (columna lumbosacra, genitales), orina completa y urocultivo; descartar DM, ITU, apnea del sueño, abuso sexual en secundaria.
- Tratamiento: educación y desmitificar, sin castigos; restringir líquidos 1-2 h antes de dormir, micción antes de acostarse, calendario, tratar la constipación.
- Alarma de enuresis (primera línea, más efectiva a largo plazo) o desmopresina 0,2-0,4 mg VO al acostarse (efecto rápido, recaída al suspender; restringir líquidos por riesgo de hiponatremia).
- Seguimiento: control cada 1-3 meses en APS; derivar si enuresis no monosintomática, secundaria con alteración urológica o refractaria.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 7 años moja la cama casi todas las noches desde siempre. Durante el día controla la micción sin urgencia ni incontinencia, no tiene constipación y el examen físico, incluido el examen de orina, es normal. Nunca ha recibido tratamiento. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Ecografía renal y vesical y uretrocistografía
B Educación y medidas conductuales (micción antes de dormir, reducir líquidos nocturnos, calendario)
C Imipramina oral
D Derivar a urología pediátrica
E Indicar pañales hasta la adolescencia

Respuesta B. Enuresis primaria monosintomática: incontinencia nocturna en mayores de 5 años que nunca han logrado control, sin síntomas diurnos. Es frecuente y benigna. El manejo inicial es desculpabilizar, educar y aplicar medidas conductuales; si fracasan, alarma de enuresis o desmopresina. No requiere imágenes si el examen y la orina son normales. La imipramina está en desuso por su toxicidad.

▶ VER CLASE 2.01.1.060 Hematuria

DX ESPECÍFICO · TX INICIAL · SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.15 · Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- Hematuria: ≥5 GR/campo en sedimento de orina centrifugada; confirmar microscópicamente (tira reactiva positiva sin GR: mioglobinuria o hemoglobinuria; orina roja sin heme: alimentos, fármacos).
- Glomerular: orina color coca-cola, GR dismórficos, cilindros hemáticos, proteinuria, HTA, edema (GNAPE, nefropatía IgA, PSH, Alport).
- No glomerular: orina roja con coágulos, GR eumórficos (ITU, hipercalciuria, litiasis, trauma, tumor de Wilms, malformaciones).
- Estudio inicial: orina completa con sedimento, urocultivo, creatinina, calciuria/creatininuria, C3, ecografía renal y vesical.
- Microhematuria aislada asintomática: repetir orina en 2-3 semanas; persistente: estudio. Hipercalciuria idiopática es causa frecuente.
- Seguimiento: derivar a nefrología si proteinuria, HTA, falla renal, hematuria glomerular persistente o historia familiar de nefropatía/sordera.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 100

Un niño de 7 años se encuentra en el preoperatorio de una cirugía de fimosis. Entre los exámenes prequirúrgicos, el examen de orina reporta 2 a 5 leucocitos por campo, 10 a 15 eritrocitos por campo y proteínas 5 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar índice albúmina/creatinina en orina
B Solicitar creatinina y calcio en una muestra de orina aislada
C Repetir el examen de orina
D Solicitar proteinuria en orina de 24 horas
E Solicitar títulos de antiestreptolisina O

Respuesta C. Microhematuria aislada, asintomática, sin proteinuria significativa, sin HTA ni edema, es un hallazgo frecuente y muchas veces transitorio. Lo primero es repetir el examen de orina (2 a 3 muestras en semanas). Solo si persiste se estudia: calciuria/creatininuria, función renal, imágenes y antecedentes familiares.

▶ VER CLASE 2.01.1.061 Hipertensión arterial

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.3 · Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- HTA pediátrica: PA ≥p95 para edad, sexo y talla en 3 ocasiones (≥13 años: ≥130/80). PA elevada p90-p95. Medir PA desde los 3 años en cada control.
- Etapa 2: ≥p95 + 12 mmHg o ≥140/90; derivar con prontitud.
- En niños pequeños predomina la HTA secundaria: renal (la más frecuente: cicatrices, glomerulopatías), renovascular, coartación aórtica, endocrinas. En adolescentes obesos, esencial.
- Estudio inicial: orina completa, creatinina, electrolitos, perfil lipídico, glicemia, ecografía renal con doppler; ecocardiograma (HVI) y fondo de ojo; PA en 4 extremidades (coartación).
- Manejo inicial: dieta DASH, baja de sal, actividad física, baja de peso; fármaco (IECA, bloqueador de calcio) si HTA sintomática, secundaria, daño de órgano blanco o falla de medidas.
- Seguimiento: derivar a nefrología pediátrica para estudio de HTA secundaria y manejo farmacológico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 6 años, asintomático, presenta presión arterial sobre el percentil 95 para su edad, sexo y talla en tres controles separados. Su IMC es normal. **¿Cuál es la causa más probable de su hipertensión?**

A Enfermedad del parénquima renal
B Hipertensión esencial
C Feocromocitoma
D Hipertiroidismo
E Hiperaldosteronismo primario

Respuesta A. En niños pequeños, sobre todo menores de 10 años y sin obesidad, la hipertensión suele ser secundaria, y la causa más frecuente es la enfermedad renal parenquimatosa (cicatrices por pielonefritis, glomerulopatías, displasias), seguida de la renovascular y la coartación aórtica. La hipertensión esencial predomina en adolescentes con obesidad o antecedentes familiares. El estudio inicial incluye orina, creatinina y ecografía renal.

▶ VER CLASE 2.01.1.062 Infección urinaria

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.13 · Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- ITU: lactante con fiebre sin foco, vómitos, irritabilidad, rechazo alimentario; preescolar/escolar con disuria, polaquiuria, enuresis secundaria. E. coli >80%.
- Muestra: sin control de esfínter, sondeo vesical o punción suprapúbica; bolsa recolectora solo descarta si es negativa. Con control: segundo chorro limpio.
- Urocultivo positivo: chorro medio ≥100.000 UFC/ml, sondeo ≥10.000 (algunas guías ≥50.000), punción suprapúbica cualquier recuento.
- Cistitis: cefadroxilo 50 mg/kg/día c/12 h o nitrofurantoína 5-7 mg/kg/día por 5-7 días. Pielonefritis ambulatoria: cefadroxilo o cefixima 7-10 días; hospitalizar si <3 meses, tóxico o vómitos (ceftriaxona o amikacina EV).
- Imágenes: ecografía renal y vesical tras primera ITU febril; uretrocistografía miccional si eco alterada, ITU atípica o recurrente (reflujo vesicoureteral); cintigrama DMSA a los 6 meses por cicatrices.
- Seguimiento: derivar a nefrología si ITU recurrente, reflujo, eco alterada o cicatrices; tratar constipación y disfunción miccional.

PREGUNTAS · 12

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 156

Niña de 8 meses con cuadro febril hasta 39,2 °C, sin otros síntomas ni alteraciones al examen físico. Se realiza un urocultivo por recolector, que resulta positivo para Escherichia coli sensible, con 45.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tratar con cefadroxilo oral
B Tratar con nitrofurantoína oral
C Tratar con amoxicilina oral
D Solicitar hemograma, VHS y PCR
E Repetir el urocultivo por sondeo vesical

Respuesta E. El urocultivo por bolsa recolectora solo es positivo si supera las 100.000 UFC por mililitro. Con 45.000, el único paso aceptable es repetirlo con una técnica fidedigna: sondeo vesical.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 50

Niño de 3 años, con antecedente de fimosis, con fiebre hasta 39,5 °C desde hace 48 horas, asociada a vómitos y malestar general. Examen cardiopulmonar y abdominal sin alteraciones relevantes. Sedimento de orina con 20 glóbulos rojos y 50 glóbulos blancos por campo, bacterias en moderada cantidad; hemograma con 14.000 leucocitos por milímetro cúbico y VHS de 42 milímetros por hora. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Balanopostitis
B Neumonía adquirida en la comunidad
C Influenza
D Síndrome hemolítico urémico
E Pielonefritis aguda

Respuesta E. La fimosis puede orientar a balanopostitis o a pielonefritis; la balanopostitis da alteraciones cutáneas del prepucio sin fiebre alta. Aquí la leucocituria elevada junto con la fiebre define la pielonefritis aguda.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 135

Un niño de 18 meses presenta un cuadro de fiebre hasta 39 grados, asociado a decaimiento e irritabilidad. La madre refiere orinas de mal olor, por lo que se realiza un examen de orina por sondeo, que da salida a un líquido con abundante bacterias, 50 piocitos por campo y escasa hematuria. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A Ciprofloxacino
B Cefadroxilo
C Nitrofurantoína
D Gentamicina
E Cefoperazona

Respuesta B. La ITU baja en pediatría se trata con cefalosporinas de primera o segunda generación. Tampoco se usan las quinolonas, por lo mismo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 29

Niño de 8 meses con fiebre, orina por recolector con leucocituria y bacterias abundantes. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Iniciar antibiótico oral de inmediato
B Repetir el examen de orina por sondeo vesical
C Hospitalizar y tratar ITU febril
D Solicitar ecografía renal y vesical
E Derivar a nefrología pediátrica

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Repetir el examen de orina por sondeo vesical (opción B). Repetir el examen de orina por sondeo vesical.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 83

Un niño de 4 años presenta disuria, asociada a molestias abdominales, sin fiebre. Su examen físico no tiene alteraciones. Se solicita sedimento de orina, que muestra 6 a 8 glóbulos blancos por campo y urocultivo, que muestra desarrollo de Escherichia coli multisensible, con 60.000 UFC por mm3. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Repetir el sedimento y urocultivo
B Iniciar cefadroxilo 50 mg/Kg/día, por 5 días
C Iniciar nitrofurantoína 5-7 mg/Kg/día, por 7 días
D Solicitar cintigrafía DSMA
E Solicitar ecografía abdominal

Respuesta A. En estricto rigor no tiene una ITU, dado que tiene menos de 100.000 colonias en el cultivo de orina obtenida por micción. Dentro de las opciones de manejo están 1. repetirlo y 2. tomar el cultivo por sonda (requiere 10.000 UFC/mm3) o por punción (basta 1 UFC). Una vez que se confirme el diagnóstico recién estaría indicado tratar (B o C sirven) y posteriormente estudiar con la ecografía (toda ITU en pediatría se estudia).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 134

Una niña de 5 años consulta por disuria dolorosa, asociado a orinas turbias y de mal olor, sin fiebre. Se solicita un examen de orina por sondeo, que muestra 20 a 30 leucocitos por campo, con 3 a 4 glóbulos rojos por campo y bacterias abundantes. El urocultivo está pendiente. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección?

A Nitrofurantoína
B Ciprofloxacino
C Metronidazol
D Amoxicilina
E Cefoperazona

Respuesta A. La ITU baja en pediatría se trata con cefalosporinas de primera generación o con nitrofurantoína. No se usan quinolonas, por su potencial afectación del cartílago de

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 117

Un niño de 14 meses presenta fiebre hasta 38,6°C desde hace dos días. El examen físico no identifica un foco, por lo que se solicitan exámenes de orina, con muestra obtenida por recolector, que muestra sedimento con 10 glóbulos blancos por campo, 2 a 4 glóbulos rojos por campo, células epiteliales en regular cantidad, bacterias en moderada cantidad y citoquímico con nitritos negativos, ausencia de glucosuria y proteinuria, ausencia de cristales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Solicitar cintigrafía renal
B Solicitar ecografía renal y vesical
C Solicitar examen de orina por sondeo
D Iniciar cefadroxilo oral
E Iniciar ceftriaxona endovenosa

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Solicitar examen de orina por sondeo (opción C).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 72

Lactante de 18 meses, irritable , con sedimento y urocultivo (+), fiebre y decaimiento hace 3 días, antibiograma sensible a imipenem, cipro, Amikacina. ¿qué tratamiento indicar? a. Amikacina b. Carbapenemicos

A Control sano habitual
B Derivar a especialista
C Hospitalizar
D Observación domiciliaria
E Iniciar tratamiento empírico

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Control sano habitual (opción A).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 81

Una paciente de 6 años, con cuadro caracterizado por disuria, polaquiuria y orinas de mal olor desde hace 2 días, no asociado a otros síntomas. Al examen físico destaca temperatura de 36.5ºC, abdomen blando, depresible y no doloroso a la palpación, puño percusión negativa. Se realiza sedimento de orina que muestra 6 eritrocitos y 15 leucocitos por campo, además se solicita urocultivo de segundo chorro en el que hay crecimiento de escherichia coli con 60.000 unidades formadoras de colonia multisensible. La conducta más adecuada en este caso es:

A Iniciar Cefadroxilo oral
B Iniciar Nitrofurantoina oral
C Solicitar Ecografía renal y vesical
D Solicitar cintigrafía renal estática
E Repetir sedimento de orina y urocultivo

Respuesta E. Urocultivo está negativo. Idealmente repetirlo por sondeo, porque el sedimento está dudoso y la clínica es sugerente. Pregunta muy rara y difícil. Probablemente venía redactada de una forma distinta en la prueba origina. De las opciones, la más aceptable, dado que el urocultivo es menor a 100 mil colonias, es la repetición.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 49

Un niño de 3 años, con antecedente de fimosis, presenta fiebre alta, hasta 39,5°C, desde hace 48 horas, asociada a vómitos y malestar general. Su examen físico muestra frecuencia cardíaca: 130x', T°: 39,0°C, faringe congestiva, examen cardiopulmonar y abdominal sin alteraciones relevantes. Se solicitan exámenes: sedimento de orina con 20 GR/campo, 50 GB/campo, bacterias en moderada cantidad; hemograma con leucocitos 14.000/mm3, VSG: 42 mm/h. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Balanopostitis
B Neumonía adquirida en la comunidad
C Influenza
D Síndrome hemolítico urémico
E Pielonefritis aguda

Respuesta E. Pielonefritis aguda: La fimosis puede orientar a balanopostitis o pielonefritis. La balanopostitis presenta alteraciones cutáneas en prepucio y glande, sin fiebre alta. La leucocituria elevada (50 GB/campo) junto con la fiebre indica pielonefritis aguda.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 8

Guagua de 2 meses con ITU x atipico (nitritos (-)), fiebre, irritabilidad, con 60 blancos, bacterias abundantes: a. Hospitalizar + ATB amplio espectro. (ITU < 2 meses, ITU Atipica) b. ATB vo y control con UC (la guagua estaba regio, sgy igual podia ser esa), no, menor a 3 es indicación absoluta de hospitalizar (mmm, pero estaba febril, así que la sospecha era PNA) Y estaba “decaído”

A Staphylococcus aureus

B Streptococcus pneumoniae

C Escherichia coli

D Pseudomonas aeruginosa

E Klebsiella pneumoniae

Respuesta A. Diagnóstico: Staphylococcus aureus (opción A).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 30

ITU febril en guagua. ATB con resistencia pero sensible a nitrofurantoína. Cual le dejas (entregaban antibiograma, era E.Coli blee positivo):

A Carbapenemico (blee se trata con carbapenemicos) b. Amikacina (¿¿pero amika le pegaba bien o no?, SII, salia sensible a AMIKA). Era amika todo el rato. Amika definitivamente c. Las E. Coli BLEE se tratan con carbapenémicos, siempre, independientemente de a qué más sea sensible

B Control sano habitual

C Derivar a especialista

D Hospitalizar

E Observación domiciliaria

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Carbapenemico (blee se trata con carbapenemicos) b. Amikacina (¿¿pero amika le pegaba bien o no?, SII, salia sensible a AMIKA). Era amika todo el rato. Amika definitivamente c. Las E. Coli BLEE se tratan con carbapenémicos, siempre, independientemente de a qué más sea sensible).

▶ VER CLASE 2.01.1.063 Insuficiencia renal aguda

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 1.1 · Injuria Renal Aguda (KDIGO) y Diferenciación Prerrenal vs Intrínseca

QUÉ HAY QUE SABER

- Lesión renal aguda: aumento de creatinina ≥1,5 veces basal o diuresis <0,5 ml/kg/h por 6-8 h (criterios pRIFLE/KDIGO).
- Prerrenal (la más frecuente: deshidratación, shock): FENa <1%, osmolaridad urinaria alta; renal: SHU (principal causa en lactantes en Chile), GNAPE, NTA, nefrotóxicos; postrenal: válvulas de uretra posterior, obstrucción.
- Estudio: creatinina, BUN, electrolitos, gases, hemograma con frotis (esquistocitos), orina completa, ecografía renal.
- Manejo inicial: corregir volemia (bolo SF 10-20 ml/kg si hipovolemia), luego balance estricto (pérdidas insensibles + diuresis), suspender nefrotóxicos, ajustar dosis de fármacos.
- Hiperkalemia >6 mEq/L o con cambios en ECG: gluconato de calcio, salbutamol, insulina con glucosa, bicarbonato; indicaciones de diálisis: hiperkalemia, sobrecarga de volumen, acidosis o uremia refractarias.
- Seguimiento: hospitalizar y derivar a nefrología pediátrica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 3 años presentó diarrea con sangre hace una semana, ya resuelta. Ahora está pálido, decaído y orina poco. Exámenes: hemoglobina 7,5 g/dL con esquistocitos en el frotis, plaquetas 45.000/mm3, LDH elevada, Coombs directo negativo y creatinina 2,1 mg/dL. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Púrpura trombocitopénica inmune

B Glomerulonefritis postestreptocócica

C Síndrome hemolítico urémico

D Anemia hemolítica autoinmune

E Deshidratación con falla prerrenal

Respuesta C. Anemia hemolítica microangiopática (esquistocitos, LDH alta, Coombs negativo), trombocitopenia e injuria renal aguda tras una diarrea disentérica es síndrome hemolítico urémico, por E. coli productora de toxina Shiga. Es la principal causa de injuria renal aguda intrínseca en preescolares en Chile. Manejo de soporte; los antibióticos no están indicados.

▶ VER CLASE 2.01.1.064 Insuficiencia renal crónica

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.1 · Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- ERC pediátrica: alteración estructural o funcional >3 meses o VFG <60 ml/min/1,73 m²; estimar con fórmula de Schwartz (0,413 × talla cm / creatinina).
- Causas: malformaciones renales y de vía urinaria (CAKUT: hipodisplasia, uropatías obstructivas, reflujo) las más frecuentes; luego glomerulopatías.
- Clínica: talla baja, anemia, poliuria/polidipsia, HTA, acidosis metabólica, osteodistrofia renal (raquitismo), retraso del desarrollo.
- Manejo inicial: controlar PA (IECA), corregir acidosis con bicarbonato, anemia (hierro, eritropoyetina), calcio/fósforo/PTH, nutrición adecuada y vacunas (hepatitis B).

- Evitar nefrotóxicos (AINE, aminoglicósidos, contraste); ajustar dosis de fármacos según VFG.
- Seguimiento: derivar a nefrología pediátrica; ERC terminal (diálisis y trasplante) es GES.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En un policlínico de nefrología infantil se revisa la etiología de los niños con enfermedad renal crónica. **¿Cuál es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en niños?**

A Nefropatía diabética
B Nefropatía hipertensiva
C Nefropatía por IgA
D Malformaciones congénitas del riñón y vía urinaria (uropatías obstructivas y displasias)
E Enfermedad renal poliquística autosómica dominante

Respuesta D. En pediatría, especialmente en menores de 5 años, la principal causa de enfermedad renal crónica son las anomalías congénitas del riñón y la vía urinaria: hipoplasia o displasia renal, uropatías obstructivas como válvulas de uretra posterior y reflujo vesicoureteral con nefropatía. Las glomerulopatías ganan importancia en escolares y adolescentes; la diabetes y la hipertensión son causas del adulto.

▶ VER CLASE 2.01.1.065 Malformaciones urogenitales

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.13 · Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Malformaciones urogenitales: hidronefrosis antenatal (la más frecuente detectada por eco), reflujo vesicoureteral, estenosis pieloureteral, válvulas de uretra posterior, riñón multiquístico, hipospadias.
- Válvulas de uretra posterior: varón con hidronefrosis bilateral, chorro débil, globo vesical, ITU precoz, falla renal; urgencia urológica.
- Hipospadias: meato ventral; no circuncidar (prepucio se usa para reparación). Hipospadias con criptorquidia bilateral: estudiar desarrollo sexual diferente (HSC).
- Hidronefrosis antenatal: eco renal post natal después de las 48-72 h (antes subestima por oliguria fisiológica); profilaxis antibiótica según grado.
- Manejo inicial: tratar ITU, profilaxis antibiótica en hidronefrosis grave o reflujo de alto grado (amoxicilina en <2 meses, luego nitrofurantoína o cefadroxilo en dosis baja).
- Seguimiento: derivar a urología/nefrología infantil.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niña de 2 años, con su segunda infección urinaria febril en 6 meses, confirmada por sondeo vesical y ya tratada con buena respuesta. La ecografía renal y vesical muestra dilatación de la pelvis renal y del uréter izquierdos. **¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?**

A Cintigrama renal con DMSA en fase aguda
B Pielografía endovenosa
C Urocultivo mensual por 1 año
D Uretrocistografía miccional
E TAC de abdomen con contraste

Respuesta D. Una ecografía alterada (ureterohidronefrosis) o una infección urinaria febril recurrente obligan a buscar reflujo vesicoureteral, la malformación más asociada a infección urinaria. La uretrocistografía miccional lo diagnostica y clasifica en grados.

▶ VER CLASE 2.01.1.066 Síndrome edematoso

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 4.1 · Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome edematoso: acumulación de líquido intersticial; en niños la causa más frecuente es renal (síndrome nefrótico).
- Orientación: edema palpebral matinal blando que migra a declive (nefrótico); con hematuria e HTA (nefrítico); con hepatomegalia y ascitis (hepático); con disnea y hepatomegalia (cardíaco); desnutrición (Kwashiorkor); enteropatía perdedora de proteínas.
- Estudio inicial: orina completa, proteinuria (índice proteinuria/creatininuria), albúmina, colesterol, creatinina, electrolitos, transaminasas; Rx de tórax si sospecha cardíaca.
- Manejo inicial: restricción de sodio, tratar la causa; diuréticos con cautela (riesgo de hipovolemia en nefrótico con albúmina muy baja).
- Banderas rojas: anasarca, dificultad respiratoria, oliguria, HTA grave, signos de hipovolemia o trombosis.
- Seguimiento: derivar a nefrología/cardiología/gastroenterología según causa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 5 años consulta por edema palpebral matinal de 5 días, que luego se extiende a las piernas. No tiene disnea, ictericia ni diarrea. Al examen la presión arterial es normal y el edema es blando, con fóvea. **¿Cuál es el examen inicial más útil para orientar la causa del edema?**

A Ecocardiograma
B TSH y T4 libre
C Pruebas hepáticas
D Ecografía abdominal
E Examen de orina completa con proteinuria

Respuesta E. En un niño con edema generalizado sin síntomas cardíacos ni hepáticos, la causa más frecuente es el síndrome nefrótico. El primer examen es la orina completa: proteinuria marcada (y luego índice proteinuria/creatininuria) junto con albuminemia y perfil lipídico. La hematuria e HTA orientan a síndrome nefrítico. Las causas cardíacas, hepáticas o por desnutrición se buscan si la orina es normal.

▶ VER CLASE 2.01.1.067 Síndrome hemolítico urémico

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Hematología 8.10 · Microangiopatías Trombóticas (MAT): PTT (Déficit ADAMTS13 / Plasmaféresis) vs SHU
Pediatría 18.11 · Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome hemolítico urémico: anemia hemolítica microangiopática (esquistocitos, LDH alta, Coombs negativo), trombocitopenia y lesión renal aguda.
- Típico: E. coli productora de toxina Shiga (O157:H7); niño <5 años con diarrea disentérica 5-10 días antes, luego palidez, oliguria, edema, petequias e HTA. Chile tiene alta incidencia; principal causa de IRA en lactantes.
- Estudio: hemograma con frotis, plaquetas, LDH, bilirrubina, creatinina, electrolitos, orina completa, coprocultivo/PCR para STEC.
- Manejo inicial: hospitalizar, balance hídrico estricto, evitar sobrecarga, tratar HTA y electrolitos; transfundir GR si Hb <7 g/dL; diálisis según necesidad.
- No usar antibióticos ni antidiarreicos en diarrea por STEC; evitar transfundir plaquetas salvo sangrado. Notificación obligatoria.
- Seguimiento: derivar a nefrología; control a largo plazo de PA, proteinuria y función renal por riesgo de ERC.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 122

Una niña de 3 años presenta, hace 4 días, un cuadro de diarrea y fiebre hasta 38ºC, a la que se agrega sangre en las deposiciones, 48 horas después. En su examen físico se ve decaída, pálida y en sus exámenes destaca hematocrito de 28%, leucocitos 9.800, plaquetas 75.000, BUN 28, creatinina 2,3 mg/dl. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Leucemia aguda
B Síndrome hemolítico urémico
C Shock Séptico
D Glomerulonefritis aguda
E Púrpura de Schölein Henoch

Respuesta B. SHU clásico: niña pequeña, diarrea con sangre, falla renal aguda grave, anemia y trombocitopenia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 61

Un niño de 5 años es hospitalizado por una neumonía con hemocultivos positivos para Streptococcus pneumoniae. Está en tratamiento con ceftriaxona endovenosa. Al tercer día evoluciona con deterioro del estado general y oliguria, por lo que se solicitan exámenes que muestran creatinina: 3,1 mg/dL, BUN: 68 mg/dL, hemograma con hematocrito: 27%, hemoglobina: 9 g/dL, glóbulos blancos: 13.000/mm³, 70% de neutrófilos y plaquetas 70.000/mm³, el tiempo de protrombina resulta 16,2 segundos y los niveles de complemento muestran C3: 81 mg/dL (normal: 90–180 mg/dL) y C4: 8,5 mg/dL (normal: 11–40 mg/dL). El sedimento de orina muestra hematuria con 15% de dismorfia. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Coagulación intravascular diseminada
B Glomerulonefritis aguda posinfecciosa
C Síndrome hemolítico urémico
D Sepsis por neumococo
E Insuficiencia renal aguda prerrenal

Respuesta C. SHU: falla renal aguda con anemia y plaquetopenia. Sus causas incluyen E. coli enterohemorrágica, Shigella y también Streptococcus pneumoniae. La glomerulonefritis posinfecciosa aparece días después, suele ser por S. pyogenes y no da plaquetopenia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 17

Un lactante de 3 años presenta, desde hace 2 días, edema de extremidades inferiores, de la cara y de la zona escrotal, asociado a malestar general. Hace 4 días está con diarrea. Al examen físico se aprecia pálido, se constata el edema blando y se observan múltiples equimosis en las extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 3,0 mg/dl, BUN: 35 mg/dl, hemograma con hematocrito: 28%, plaquetas: 120.000, blancos: 11.000 por mm3, frotis con esquistocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? El diagnóstico más probable es:

A Síndrome nefrótico
B Púrpura de Schönlein Henoch
C Insuficiencia renal prerrenal
D Glomerulonefritis aguda posestreptocócica
E Síndrome hemolítico urémico

Respuesta E. Es un SHU clásico: falla renal, anemia hemolítica y plaquetopenia. Suele estar precedido por diarrea en el 70% de los casos. La IRA prerrenal no tiene edema.

▶ VER CLASE 2.01.1.068 Síndrome nefrítico

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 4.3 · Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome nefrítico: hematuria (orina coca-cola), edema, HTA y oliguria, con o sin falla renal.
- GNAPE: 5-12 años, 1-3 semanas post faringoamigdalitis o 3-6 semanas post impétigo por S. pyogenes; C3 bajo transitorio (normaliza en 6-8 semanas), ASO elevado.
- Estudio: orina completa (GR dismórficos, cilindros hemáticos), creatinina, electrolitos, C3, C4, ASO, proteinuria.
- Manejo inicial: restricción de sodio y líquidos, furosemida 1-2 mg/kg si edema o HTA, antihipertensivo (amlodipino/nifedipino) si HTA persiste; penicilina si infección estreptocócica activa.
- Complicaciones: encefalopatía hipertensiva (convulsiones), insuficiencia cardíaca congestiva, IRA.
- Derivar a nefrología si C3 bajo >8 semanas, proteinuria nefrótica, falla renal progresiva o hematuria macroscópica persistente; microhematuria puede durar hasta 1-2 años.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 64

Un niño de 7 años presenta edema de párpados y de extremidades inferiores, asociado a orinas oscuras. Al examen tiene edema palpebral y de ambas piernas, con presión arterial de 127/85 mmHg. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Síndrome nefrítico
B Síndrome nefrótico
C Enfermedad de Berger
D Necrosis tubular aguda
E Síndrome hemolítico urémico

Respuesta A. Edema, hematuria macroscópica (orinas oscuras) e hipertensión (127/85 es elevada para 7 años) conforman el síndrome nefrítico; en escolares la causa más frecuente es la glomerulonefritis postestreptocócica. El nefrótico cursa con edema y proteinuria masiva, sin HTA ni hematuria importante. La enfermedad de Berger da hematuria sincrónica con la infección, generalmente sin edema.

▶ VER CLASE 2.01.1.069 Síndrome nefrótico

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 4.1 · Síndrome Nefrótico y Complicaciones Trombóticas

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome nefrótico: proteinuria masiva (≥40 mg/m²/h o índice proteinuria/creatininuria >2), hipoalbuminemia <2,5 g/dL, edema y dislipidemia.
- Causa más frecuente en niños 2-8 años: enfermedad por cambios mínimos, que responde a corticoides; sin hematuria, HTA ni falla renal.
- Tratamiento inicial (por especialista): prednisona 60 mg/m²/día (máx 60 mg) por 4-6 semanas y luego 40 mg/m² en días alternos 4-6 semanas.
- Medidas: dieta sin sal, normoproteica; diuréticos con precaución; albúmina EV solo si edema refractario o hipovolemia sintomática.
- Complicaciones: peritonitis bacteriana espontánea por neumococo, trombosis, hipovolemia. Biopsia si edad <1 o >10 años, hematuria, HTA, C3 bajo o corticorresistencia.
- Seguimiento: derivar a nefrología pediátrica; vigilar recaídas con tira reactiva en orina en domicilio.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 60

Un lactante de 2 años es traído por presentar aumento de volumen facial y edema de las extremidades inferiores. La madre refiere, además, que presenta orinas espumosas desde hace una semana. Al examen físico se observa edema blando de las extremidades inferiores y de la cara. Su frecuencia cardíaca es 80 latidos por minuto y su presión arterial es 87/54 mmHg. Se solicitan exámenes, destacando examen de orina con 2 glóbulos rojos por campo y proteinuria: 4+, creatinina: 0,7 mg/dL, BUN: 12 mg/dL, albuminemia: 2,7 g/dL, colesterol total: 310 mg/dL y triglicéridos plasmáticos: 560 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar prednisona vía oral en alta dosis

B Derivar para biopsia renal

C Iniciar diuréticos

D Indicar dieta baja en sodio y en potasio

E Realizar hemodiálisis

Respuesta A. Síndrome nefrótico puro en un niño: lo más probable es la enfermedad por cambios mínimos (90 % en niños), que se trata con prednisona oral en dosis altas sin biopsia previa. La biopsia se reserva para la falta de respuesta o el nefrótico impuro.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 60

Un niño de 2 años es traído por aumento de volumen facial y edema de las extremidades inferiores. La madre refiere orinas espumosas desde hace una semana. Al examen físico se observa edema blando de extremidades inferiores y cara, frecuencia cardíaca 80/min y presión arterial 87/54 mmHg. Exámenes: orina con 2 glóbulos rojos por campo y proteinuria 4+, creatinina 0,7 mg/dL, BUN 12 mg/dL, albuminemia 2,7 g/dL, colesterol total 310 mg/dL y triglicéridos 560 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar prednisona vía oral en dosis alta

B Derivar para biopsia renal

C Iniciar diuréticos

D Indicar dieta baja en sodio y en potasio

E Realizar hemodiálisis

Respuesta A. Edema, proteinuria masiva, hipoalbuminemia y dislipidemia sin hematuria, HTA ni falla renal es un síndrome nefrótico puro, que entre 1 y 10 años corresponde casi siempre a enfermedad de cambios mínimos. Se trata empíricamente con prednisona oral en dosis alta (60 mg/m2/día). La biopsia se reserva para corticorresistencia, edad atípica o síndrome impuro.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 22

Un niño de 4 años, presenta un cuadro de 10 días de evolución de edema bipalpebral, a lo que se ha agregado, en los últimos dos días, oliguria y orinas espumosas. Al examen físico presenta presión arterial 102/62 mmHg, FC: 80x', edema facial y de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca examen de orina con proteínas ++, creatininemia 0,9 mg/dl y BUN: 20 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

A Síndrome nefrótico

B Glomerulonefritis aguda

C Insuficiencia renal crónica

D Síndrome hemolítico urémico

E Nefritis intersticial

Respuesta A. Es un síndrome nefrótico clásico (orina espumosa, edema y proteinuria), aunque le faltan los exámenes confirmatorios (proteinuria cuantitativa o índice proteinuria / creatininuria, albumnemia y perfil lipídico). No hay hematuria dismórfica, así que no puede ser una glomerulonefritis. No tiene insuficiencia renal, así que no puede ser ninguna de las otras opciones.

▶ VER CLASE 2.01.1.070 **Trastornos del equilibrio ácido-base** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 3.3 · Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia

QUÉ HAY QUE SABER

- Interpretación: pH <7,35 acidosis, >7,45 alcalosis; HCO3 bajo metabólica, pCO2 alta respiratoria. Calcular anión gap = Na - (Cl + HCO3) (normal 8-12).
- Acidosis metabólica con AG elevado: cetoacidosis diabética, láctica (shock), IRA, intoxicaciones (salicilatos, metanol). AG normal (hiperclorémica): diarrea (la más frecuente en niños), acidosis tubular renal.
- Alcalosis metabólica hipoclorémica hipokalémica: vómitos persistentes, estenosis hipertrófica del píloro, fibrosis quística, diuréticos.
- Compensación esperada en acidosis metabólica: pCO2 = 1,5 × HCO3 + 8 ± 2 (Winter); si no cumple, trastorno mixto.
- Tratamiento: corregir la causa (rehidratar en diarrea, insulina en CAD, perfundir en shock); bicarbonato solo en acidosis grave con pH <7,1 o pérdidas de bicarbonato; en píloro corregir con SF y potasio antes de cirugía.
- Seguimiento: derivar a nefrología si acidosis tubular renal o trastorno persistente sin causa clara.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 10 meses con diarrea acuosa abundante de 3 días llega deshidratado. Gases venosos: pH 7,24, PCO2 30 mmHg, HCO3- 13 mEq/L. Electrolitos: Na+ 137 mEq/L, K+ 3,2 mEq/L y Cl- 112 mEq/L. **¿Cuál es el trastorno ácido-base?**

A Acidosis metabólica con anión gap normal (hiperclorémica)

B Acidosis metabólica con anión gap aumentado

C Acidosis respiratoria

D Alcalosis metabólica hipoclorémica

E Trastorno mixto: acidosis respiratoria y alcalosis metabólica

Respuesta A. pH bajo con bicarbonato bajo es acidosis metabólica, con compensación respiratoria (PCO2 baja). Anión gap = 137 - (112 + 13) = 12, normal: acidosis hiperclorémica, típica de la pérdida digestiva de bicarbonato en la diarrea. Si hubiera shock con hipoperfusión se agregaría acidosis láctica con gap aumentado. Los vómitos, en cambio, dan alcalosis hipoclorémica.

▶ VER CLASE 2.01.1.071 Trastornos hidro-electrolíticos

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 2.3 · Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Requerimientos de mantención (Holliday-Segar): 100 ml/kg para primeros 10 kg, 50 ml/kg de 10-20 kg y 20 ml/kg sobre 20 kg; Na 2-3 y K 1-2 mEq/kg/día. Usar soluciones isotónicas en hospitalizados.
- Hiponatremia (Na <135): vómitos/diarrea con aporte hipotónico, SIADH (meningitis, neumonía). Sintomática grave (convulsiones): NaCl 3% 2-3 ml/kg en bolo; corrección ≤8-10 mEq/L en 24 h (riesgo de mielinolisis).
- Hipernatremia (Na >145): deshidratación con pérdida de agua, mal técnica de fórmula, diabetes insípida; corregir en 48-72 h, descenso ≤10-12 mEq/L/día (riesgo de edema cerebral).
- Hipokalemia: diarrea, vómitos, diuréticos; debilidad, íleo, onda U. Hiperkalemia: falla renal, hemólisis; ondas T picudas, QRS ancho: gluconato de calcio, salbutamol, insulina + glucosa.
- Deshidratación isonatrémica la más frecuente; hipernatrémica tiene menos signos clínicos y piel pastosa.
- Seguimiento: control electrolítico seriado; derivar si trastorno grave, recurrente o de causa no aclarada.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 155

Un niño de 6 años fue operado de un tumor cerebral hace 7 días. Desde entonces ha presentado volúmenes urinarios aumentados, de 4,5 litros al día. Exámenes: glicemia de ayuno 103 mg/dL, Na+ 154 mEq/L, K+ 4,9 mEq/L; orina con sedimento normal, densidad 1.005 y osmolaridad urinaria 100 mOsm/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Síndrome perdedor de sal cerebral

B Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética

C Insuficiencia suprarrenal

D Diabetes insípida

E Diabetes mellitus

Respuesta D. Poliuria con orina diluida (osmolaridad 100 mOsm/L, densidad 1.005) e hipernatremia tras una cirugía selar o hipotalámica es diabetes insípida central por déficit de ADH. El SIADH y el perdedor de sal cerebral dan hiponatremia; la diabetes mellitus da glucosuria con orina concentrada. Se trata con desmopresina y manejo hídrico cuidadoso.

▶ VER CLASE 2.01.1.072 Alteraciones del desarrollo puberal

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.1 · Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Pubertad normal: niña inicio con telarquia entre 8-13 años (menarquia ~2 años después); niño con aumento testicular ≥4 ml entre 9-14 años. Evaluar con estadios de Tanner.
- Pubertad precoz: caracteres sexuales antes de 8 años en niñas o 9 en niños. Central (dependiente de gonadotropinas): en niñas mayoría idiopática; en niños buscar tumor SNC (RM).
- Periférica: hiperplasia suprarrenal congénita, tumores gonadales/suprarrenales, McCune-Albright, exposición a esteroides. Telarquia prematura aislada y pubarquia prematura pueden ser variantes benignas.
- Pubertad retrasada: sin telarquia a los 13 años o sin crecimiento testicular a los 14; causa más frecuente retraso constitucional (edad ósea retrasada, historia familiar); descartar Turner, Klinefelter, hipogonadismo, enfermedad crónica.
- Estudio inicial: curva de crecimiento (velocidad acelerada en precoz), edad ósea; LH, FSH, estradiol/testosterona y RM por especialista.
- Seguimiento: derivar a endocrinología infantil; pubertad precoz central se trata con análogos de GnRH.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 162

Un niño de 8 años es traído por presentar mal olor axilar desde hace semanas, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia vello púbico escaso y testículos de 4 cc de volumen. Su índice de masa corporal está en percentil 50 para su edad y sexo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Pubertad precoz central
B Pubertad precoz periférica
C Pubertad temprana
D Hiperplasia suprarrenal
E Adrenarquia temprana

Respuesta A. Pubertad precoz en varones es la aparición de caracteres sexuales antes de los 9 años. Un volumen testicular de 4 cc o más indica estimulación por gonadotropinas, es decir, activación del eje hipotálamo-hipófisis-gónada: pubertad precoz central. En la periférica o la adrenarquia (o la HSC) aparece vello y olor con testículos prepuberales.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 151

Una niña de 10 meses de edad tiene mamas en desarrollo Tanner II, bilateral. Su crecimiento ha sido adecuado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Solicitar ecografía mamaria
B Solicitar cariograma
C Observar y controlar en 2 meses
D Solicitar niveles plasmáticos de estrógeno y progesterona
E Solicitar niveles plasmáticos de 17-OH-progesterona

Respuesta C. La presencia de botón mamario es normal en los recién nacidos y suele durar unas pocas semanas, aunque es posible que persista, incluso hasta los 12 meses. Además, la respuesta suele ser "observar" en cualquier pregunta de pediatría que sea más o menos así: "un niño tiene una cosa rara que no tengo idea, pero todo lo demás está normal".

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 146

Un niño de 8 años presenta olor axilar. ¿Qué hallazgo debe buscarse para determinar si tiene una pubertad precoz?

A Ginecomastia
B Elevación de la 17 hidroxiprogesterona
C Vello púbico
D Aumento de la velocidad de crecimiento
E Aumento de volumen testicular

Respuesta E. Al aumento de volumen testicular es el primer signo de pubertad precoz. Sin embargo también debe evaluarse la presencia de vello púbico, porque es un signo de pubertad precoz igualmente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 172

Una niña de 9 años, sin antecedentes de importancia, consulta por dolor mamario derecho. Al examen físico presenta mama derecha en Tanner II y mama izquierda en Tanner I, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

A Realizar ecografía mamaria
B Controlar en 1 año
C Solicitar resonancia magnética de silla turca
D Realizar ecografía pelviana
E Solicitar 17-OH-progesterona

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Controlar en 1 año (opción B). Es una telarquia normal (inicio puberal), que puede ser asimétrica al inicio.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 62

Un adolescente de 13 años consulta por aumento de volumen doloroso en relación con la mama derecha. No presenta antecedentes de importancia y sus controles de niño sano han sido normales. Al examen físico, se constata aumento de volumen de 3 cm de diámetro retroareolar derecho, sensible a la palpación, y desarrollo puberal genital y pubiano Tanner 3. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Solicitar ecogra:a mamaria
B Solicitar niveles plasmá2cos de prolac2na
C Controlar en 6 meses
D Solicitar niveles plasmá2cos de testosterona, FSH y LH
E Realizar biopsia de la lesión

Respuesta C. Tiene una ginecomastia puberal benigna, la que se observa. Ya Gene desarrollo puberal, lo que es esperable para su edad (pubertad normal en niños comienza entre los 9 y 14 años; en niñas comienza entre los 8 y 13 años). Los signos de alarma en una ginecomastia son 1. Inicio en adulto o en prepúber (no puberal), 2. Tamaño > 4 cm, 3. Características de cáncer (dura, secreción sanguinolenta, etc.).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 36

Un niño de 7 años presenta olor axilar, vello púbico en Tanner 2, testículos de 2 cc de volumen. Se solicita radiografía de mano, que muestra edad ósea acorde con la edad cronológica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Tumor suprarrenal

B Pubertad precoz central

C Pubertad precoz periférica

D Hiperplasia suprarrenal congénita

E Adrenarquia normal

Respuesta E. Es una adrenarquia normal (olor axilar y en varones puede haber una ligera pu- barquia). Los testículos pequeños hacían imposible una pubertad precoz central y la pubertar precoz periférica es algo muy raro, que habría tenido alteraciones de la edad ósea.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 16

Niño de 13 años con ginecomastia unilateral y masa 3 cm retroareolar, genitales tanner 3: (repetida años anteriores) a. Observar 1 año

B Eco mamaria

B Control sano habitual

C Derivar a especialista

D Hospitalizar

E Observación domiciliaria

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (). :::note El metronidazol en monodosis de 2 g es la elección para tricomoniasis, NO para vaginosis.

▶ VER CLASE 2.01.1.073 **Diabetes** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 4.2 · Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH

QUÉ HAY QUE SABER

- DM1: la más frecuente en niños; poliuria, polidipsia, polifagia, baja de peso, enuresis secundaria. Glicemia ≥200 mg/dL con síntomas o ayuno ≥126 mg/dL confirma. DM1 es GES.
- Cetoacidosis diabética (forma de debut frecuente): glicemia >200, pH <7,3 o HCO3 <15, cetonemia/cetonuria; vómitos, dolor abdominal, respiración de Kussmaul, deshidratación.
- Manejo inicial CAD: SF 10-20 ml/kg en 1 h, luego rehidratar en 48 h; insulina cristalina 0,05-0,1 U/kg/h EV tras la primera hora sin bolo; agregar potasio cuando haya diuresis y K <5,5; no usar bicarbonato.
- Riesgo de edema cerebral en CAD (cefalea, bradicardia, compromiso de conciencia): manitol 0,5-1 g/kg o NaCl 3%; evitar rehidratación rápida.
- DM2 en adolescentes obesos con acantosis nigricans; tratar con estilo de vida y metformina, insulina si HbA1c ≥8,5% o cetosis.
- Seguimiento: derivar a endocrinología infantil; insulinoterapia basal-bolo, educación, metas HbA1c <7%; tamizaje de tiroides y celiaquía.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 19

Un paciente de 12 años consulta por un cuadro de malestar general, asociado a bajo de peso, que en las últimas horas se le agrega poliuria importante. Consulta porque en las últimas horas se agrega gran compromiso del estado general, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está taquicárdico, soporoso, con polipnea y signos de deshidratación. En sus exámenes presenta glicemia de 470 mg/dl, sodio de 143 mEq/L, potasio de 4,8 mEq/L, cloro de 97 mEq/L, bicarbonato de 12 mEq/L y pH de 7,05. **¿Qué fluido debe administrarse a este paciente?**

A Suero glucosado

B Suerlo glucosalino

C Solución salina al 0,45%

D Solución salina al 0,9%

E Suloción ringer lactato

Respuesta D. Cetoacidosis (glicemia > 250, pH 7,05, HCO_3 12, gap 34) con deshidratación y compromiso de conciencia. La primera medida es expandir con NaCl 0,9%. El suero al 0,45% se decide después de la primera hora según el sodio corregido; el glucosado, cuando la glicemia llega a ≤ 200.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 41

Un niño de 11 años es llevado al servicio de urgencia por sus padres, debido a que presenta compromiso de conciencia desde hace algunos minutos. Sus padres refieren que desde hace 4 días presenta poliuria, polidipsia y malestar general. Al examen físico destaca frecuencia cardíaca: 150 lpm, presión arterial: 100/60 mmHg, temperatura: 37°C y sopor superficial. En la exploración neurológica no tiene signos focales. Entre los exámenes de laboratorio destacan glicemia: 320 mg/dL; gases venosos con pH: 7,11, bicarbonato plasmático: 12 mEq/L, exceso de base: -9, $PaCO_2$: 24 mmHg; cetonemia y cetonuria positivas; sodio plasmático: 145 mEq/L, potasio plasmático: 5,1 mEq/L y creatinina plasmática: 1,8 mg/dL. **¿Cuál es la primera medida a administrar?**

A Suero fisiológico 20 cc/kg endovenoso
B Insulina endovenosa
C Adrenalina endovenosa
D Cloruro de potasio intravenoso
E Oxígeno por mascarilla de recirculación

Respuesta A. Cetoacidosis de debut con deshidratación, taquicardia y falla renal prerrenal. La primera medida es el volumen con suero fisiológico (15–20 ml/kg en la primera hora). La insulina va después de iniciar la expansión; el potasio está en 5,1 y no requiere aporte inmediato.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 41

Un niño de 11 años es llevado al servicio de urgencia por compromiso de conciencia desde hace algunos minutos. Sus padres refieren que desde hace 4 días presenta poliuria, polidipsia y malestar general. Al examen físico: FC 150/min, PA 100/60 mmHg, temperatura 37 °C y sopor superficial, sin signos neurológicos focales. Laboratorio: glicemia 320 mg/dL, gases venosos con pH 7,11, bicarbonato 12 mEq/L, exceso de base -9, PaCO2 24 mmHg, cetonemia y cetonuria positivas, Na+ 145 mEq/L, K+ 5,1 mEq/L y creatinina 1,8 mg/dL. **¿Cuál es la primera medida a administrar?**

A Suero fisiológico 20 mL/kg endovenoso
B Insulina endovenosa
C Adrenalina endovenosa
D Cloruro de potasio endovenoso
E Oxígeno por mascarilla de recirculación

Respuesta A. Es una cetoacidosis diabética grave (pH menor a 7,1 a 7,2) en un debut de diabetes tipo 1, con deshidratación y taquicardia. La primera medida es expandir volumen con suero fisiológico (10 a 20 mL/kg en la primera hora).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 100

Cabro chico dm 1 con CAD, PA 90/60, FC 80, conducta inicial:

A bolo 20mg kg en 30 min b. bolo 10ml/kg en 1 horas (puse esta porque para los signos vitales a su edad no estaba shockeado)
C Insulina
C Observación clínica
D Derivar a urgencia
E Control ambulatorio

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: bolo 20mg kg en 30 min b. bolo 10ml/kg en 1 horas (puse esta porque para los signos vitales a su edad no estaba shockeado) (opción A).

▶ VER CLASE **2.01.1.074** **Hiperplasia suprarrenal congénita** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.13 · Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario

QUÉ HAY QUE SABER

- Hiperplasia suprarrenal congénita: déficit de 21-hidroxilasa (>90%), autosómica recesiva; déficit de cortisol y aldosterona con exceso de andrógenos.
- Forma perdedora de sal: crisis suprarrenal a las 1-3 semanas de vida: vómitos, deshidratación, hiponatremia, hiperkalemia, hipoglicemia, shock.
- RN femenino con genitales ambiguos (virilización); varón con genitales normales o hiperpigmentación escrotal, se diagnostica por crisis. Forma no clásica: pubarquia precoz, hirsutismo, aceleración de edad ósea.
- Diagnóstico: 17-OH progesterona elevada; electrolitos y glicemia.
- Manejo inicial de crisis: SF 20 ml/kg, glucosa, hidrocortisona 50-100 mg/m² EV; tratar hiperkalemia. Crónico: hidrocortisona y fludrocortisona por especialista.
- Seguimiento: derivar a endocrinología infantil; genitales ambiguos es urgencia médica y social (no asignar sexo hasta estudio).

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 161

Un niño de 14 años consulta por dolor abdominal y vómitos de 3 días de evolución, con tendencia a la deshidratación. Hace dos meses estuvo hospitalizado por un cuadro similar, para hidratación endovenosa. Al examen físico tiene FC: 110x', PA: 110/70 mmHg, T°: 36,8°C. Se solicitan exámenes, que muestran glicemia: 36 mg/dl, sodio: 126 mEq/L, potasio: 5,8 mEq/L, pH: 7,32, bicarbonato: 16 mEq/L. **El examen de elección para confirmar el diagnóstico es:**

A Niveles plasmáticos de cortisol basal

B Prueba de tolerancia a la glucosa con curva de insulina

C Creatinina plasmática

D Amilasemia

E Endoscopía digestiva alta

Respuesta A. Vómitos a repetición con deshidratación, hipoglicemia, hiponatremia e hiperkalemia: sospecha de insuficiencia suprarrenal. Se estudia con cortisol basal y, si no es concluyente, con test de estimulación con ACTH. De las opciones, el cortisol basal es la correcta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 6

Una lactante de 2 meses con cuadro de dolor abdominal y vómitos desde hace semanas que en las últimas horas ha empeorado asociándose fiebre, taquipnea y compromiso de conciencia. Al su ingreso destaca PA: 40/20, FC 130x', examen pulmonar con crépitos difusos. Se solicitan exámenes de laboratorio donde destaca creatinina 0.9, glicemia 40, Na+ 132, K+ 5.7, hemograma con leucocitosis. Se inicia Ceftriaxona y aporte de suero fisiológico en bolo sin respuesta luego de una hora. **El fármaco de elección para el manejo de esta paciente es:**

A Vancomicina

B Noradrenalina

C Hidrocortisona

D Vasopresina

E Dopamina

Respuesta C. Hiperplasia suprarrenal congénita con crisis suprarrenal gatillada por una infección: shock que no responde al volumen, hiponatremia, hiperkalemia e hipoglicemia. El fármaco de elección es la hidrocortisona; las aminas no revierten el shock sin cortisol.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 160

Una niña de 7 años, con antecedente de hiperplasia suprarrenal congénita, en tratamiento con hidrocortisona y fludrocortisona, consulta por cuadro de 4 días de diarrea, fiebre y malestar general. Al examen físico tiene leve taquicardia y algunos signos de deshidratación. **Además de la reposición de volumen, ¿qué conducta es la más adecuada?**

A Fludrocortisona endovenosa

B Betametasona oral

C Prednisona oral

D Hidrocortisona endovenosa

E Aumentar la dosis de hidrocortisona oral

Respuesta D. Paciente con insuficiencia suprarrenal que se descompensa por una infección con diarrea: se sospecha crisis suprarrenal y se trata con un corticoide de acción rápida por vía endovenosa, la hidrocortisona. La vía oral no asegura la absorción.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 6

Una lactante de 2 meses presenta dolor abdominal y vómitos desde hace semanas, que en las últimas horas han empeorado, asociándose fiebre, taquipnea y compromiso de conciencia. Al ingreso: PA 40/20 mmHg, FC 130/min y crépitos pulmonares difusos. Laboratorio: creatinina 0,9 mg/dL, glicemia 40 mg/dL, Na+ 132 mEq/L, K+ 5,7 mEq/L y leucocitosis. Se inicia ceftriaxona y bolo de suero fisiológico, sin respuesta luego de una hora. **¿Cuál es el fármaco de elección para el manejo de esta paciente?**

A Vancomicina

B Noradrenalina

C Hidrocortisona

D Vasopresina

E Dopamina

Respuesta C. Vómitos de semanas, hipoglicemia, hiponatremia e hiperkalemia con shock refractario a fluidos en un lactante sugieren crisis suprarrenal, probablemente por hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal, descompensada por una infección. El tratamiento es hidrocortisona endovenosa en dosis de estrés (50 a 100 mg/m2), junto con fluidos y corrección de la glicemia; los vasopresores no responden sin cortisol.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 114

Un niño de 7 años consulta por dolor abdominal y vómitos de 3 días de evolución, con tendencia a la deshidratación. Hace dos meses estuvo hospitalizado por un cuadro similar, para hidratación endovenosa. Al examen físico tiene FC: 110x', PA: 110/70 mmHg, T°: 36,8°C. Se solicitan exámenes, que muestran glicemia: 46 g/dl, sodio: 130 mEq/L, potasio: 5,8 mEq/L, pH: 7,32, bicarbonato: 16 mEq/L. El examen de elección para confirmar el diagnóstico es:

A Niveles plasmáticos de cortisol basal
B Insulinemia basal
C Creatinina plasmática
D Amilasemia
E Cetonemia

Respuesta A. La sospecha es una insuficiencia suprarrenal (hiperplasia suprarrenal congénita o HSRC es lo más frecuente en pediatría), por la acidosis metabólica, hipoglicemia, tendencia al compromiso hemodinámico, hiperkalemia e hiponatremia. La mera sospecha obliga a dar corticoides EV. De las opciones, medir el cortisol es lo más correcto, aunque en niños es fundamental, además, medir la 17-OH-progesterona, por ser el marcador específico de la HSRC.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 70

Un recién nacido de 28 semanas, comienza con decaimiento y vómitos, desde hace una semana, con tendencia a la deshidratación. Al examen físico, está hipotenso, taquicárdico, con genitales masculinos, sin otros hallazgos. Sus electrolitos muestran Na+: 129 mEq/l, K+: 6,5 mEq/L, Cl: 89 mEq/L. Además, de la solución fisiológica, ¿qué medicamento se debe administrar en el manejo inicial de este paciente?

A Ondasentrón
B Omeprazol
C Calcio
D Cefotaximo
E Hidrocortisona

Respuesta E. Tiene una crisis suprarrenal, por hiperplasia suprarrenal congénita (por ser niño). Sugieren esto la clínica, la hipoNa+ y a hiperK+. Se trata con corticoides ev ante la sola sospecha.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 58

Un niño de 8 años ingresa por un cuadro de decaimiento y malestar general, con diarrea y vómitos. Está somnoliento y con compromiso hemodinámico, con FC: 120x' y PA: 70/30 mmHg. Se administran dos bolos de suero fisiológico de 20 cc/kg de peso, sin lograr estabilizarlo. En sus exámenes destaca glicemia 62 mg/dl y pH: 7,29, con exceso de base: -16. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

A Administrar hidrocortisona endovenosa 2mg/kg de peso
B Administrar un tercer bolo de suero fisiológico 20 cc/Kg de peso
C Administrar solución glucosalina 1.700 cc/m2 de superficie corporal
D Administrar plasma fresco 20 cc/kg de peso
E Administrar bicarbonato de sodio 2 mEq/Kg de peso

Respuesta A. La sospecha es una insuficiencia suprarrenal (hiperplasia suprarrenal congénita es lo más frecuente en pediatría), por la acidosis metabólica, con tendencia a la hipoglicemia y shock refractario. La mera sospecha obliga a dar corticoides EV.

▶ VER CLASE **2.01.1.075** **Hipotiroidismo** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Endocrinología 1.4 · Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito
Pediatría 18.21 · Tamizaje Neonatal Universal en Chile: Fenilcetonuria (PKU), Hipotiroidismo Congénito (HC) y Tamizaje Auditivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipotiroidismo congénito: causa prevenible de discapacidad intelectual; tamizaje neonatal universal con TSH en sangre de talón a las 40 h-7 días (programa de pesquisa neonatal).
- Clínica tardía: ictericia prolongada, macroglosia, hernia umbilical, fontanela posterior amplia, hipotonía, constipación, llanto ronco, piel seca.
- TSH elevada en tamizaje: confirmar con TSH y T4 libre en sangre venosa e iniciar levotiroxina 10-15 µg/kg/día de inmediato, sin esperar imágenes.
- Hipotiroidismo adquirido (tiroiditis de Hashimoto, el más frecuente en escolares): disminución de velocidad de crecimiento, bocio, aumento de peso, bajo rendimiento escolar; anticuerpos antiTPO.
- TSH alta con T4 libre baja: hipotiroidismo primario; levotiroxina 2-5 µg/kg/día según edad en adquirido.
- Seguimiento: derivar a endocrinología infantil; controles de TSH/T4L frecuentes en el primer año y evaluación del desarrollo.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 53

Un lactante de 3 meses, diagnosticado de hipotiroidismo congénito, en tratamiento con levotiroxina 25 mg/día. Se solicita TSH que resulta 0,09 UI/L (VN: 0,7 a 5,7) y T4 libre: 2,18 ng/dl (VN: 0,9 a 2,1). **La conducta más adecuada es:**

A Suspender la levotiroxina
B Subir la dosis de levotiroxina
C Repetir la TSH en 6 semanas
D Disminuir la dosis de levotiroxina
E Solicitar cintigrafía tiroidea

Respuesta D. TSH suprimida con T4 libre sobre lo normal: el lactante está sobretratado y se disminuye la dosis. El hipotiroidismo congénito no se suspende, porque la glándula no se va a recuperar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 53

Lactante de 3 meses, diagnosticado de hipotiroidismo congénito, en tratamiento con levotiroxina. TSH: 0,09 (normal 0,7 a 5,7). T4 libre: 2,18 (normal 0,9 a 2,1). **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Suspender la levotiroxina
B Subir la dosis de levotiroxina
C Repetir la TSH en 6 semanas, sin cambios
D Disminuir la dosis de levotiroxina
E Solicitar cintigrafía tiroidea

Respuesta D. La TSH está bajo lo normal y la T4 libre sobre lo normal: el lactante está sobretratado. La conducta es disminuir la dosis de levotiroxina y reevaluar, no suspenderla, porque el tratamiento de por vida sigue siendo necesario.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 1 mes, nacido de término en parto domiciliario rural, sin controles ni tamizaje de talón. La madre lo describe muy tranquilo, duerme todo el día, le cuesta mamar y tiene el abdomen distendido. Al examen: fontanela posterior amplia de 1,5 cm, ictericia leve, macroglosia, llanto ronco y hernia umbilical de 2 cm reducible. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar ecografía de tiroides como primer examen
B Solicitar TSH y T4 libre en sangre venosa, e iniciar levotiroxina oral
C Indicar fórmula libre de fenilalanina de forma empírica
D Control en un mes más, ya que a esta edad puede ser variante normal
E Solicitar cintigrama tiroideo antes de decidir cualquier tratamiento

Respuesta B. El cuadro reúne los signos tardíos clásicos del hipotiroidismo congénito, que se debió pesquisar con el tamizaje que nunca se tomó. La conducta inmediata es confirmar con TSH y T4 libre en sangre venosa e iniciar levotiroxina oral sin retraso, para minimizar el daño en el desarrollo.

▶ VER CLASE **2.01.1.076** **Talla baja** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.1 · Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Talla baja: talla < -2 DE (p3) para edad y sexo, o velocidad de crecimiento bajo p25, o talla muy por debajo de la talla diana familiar.
- Variantes normales: talla baja familiar (velocidad y edad ósea normales, padres bajos) y retraso constitucional del crecimiento (edad ósea retrasada, pubertad tardía, talla final normal).
- Patológicas: desproporcionada (displasias óseas) o proporcionada: endocrinas (hipotiroidismo, déficit de GH, Cushing: niño bajo y con sobrepeso), enfermedades crónicas (celiaquía, ERC, cardiopatía), Turner, PEG sin recuperación, desnutrición.
- Estudio inicial: curva de crecimiento, talla diana (talla padre + madre ± 13 cm / 2), proporciones corporales, edad ósea, hemograma, VHS, creatinina, electrolitos, gases venosos, TSH/T4L, antitransglutaminasa IgA, orina completa; cariotipo en niñas.
- Banderas rojas: velocidad de crecimiento baja, talla < -3 DE, desproporción, dismorfias, bajo peso para talla (enfermedad crónica).
- Seguimiento: derivar a endocrinología infantil si estudio alterado o velocidad de crecimiento disminuida; variantes normales se controlan en APS cada 6 meses.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 58

Un niño de 11 años es traído por sus padres por ser el más bajo de su curso. Ha crecido en el percentil 2 para su edad desde hace años según su curva de crecimiento y al examen físico tiene desarrollo puberal Tanner 1, con testículos de 2 cc. Sus padres tienen estatura promedio para la población. La radiografía de carpo muestra edad ósea de 8 años y 6 meses. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Talla baja familiar
B Hipogonadismo
C Acondroplasia
D Enanismo hipofisario
E Retardo constitucional del crecimiento

Respuesta E. Talla baja con velocidad de crecimiento normal (crece en su carril), pubertad aún no iniciada y edad ósea retrasada más de 2 años respecto de la cronológica, con padres de talla normal, es retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. En la talla baja familiar la edad ósea es acorde a la edad y los padres son bajos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 15

Niña de 8 años consulta por talla baja, tiene percentil de crecimiento 4, con velocidad de crecimiento normal, y edad ósea de 7 años 10 meses, madre mide 1.52 y padre 1.65: cual es la conducta a seguir

A Controlar en 6 meses
B Pedir GH
C Pedir TSH y T4 (no era talla baja, es <p3)
D Control sano habitual
E Derivar a especialista

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Controlar en 6 meses (opción A).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 14

Una niña de 8 años es traída por su madre, por talla baja. Está creciendo en el percentil 5 para la edad, con velocidad de crecimiento normal. Su madre mide 158 cm y su padre mide 166 cm. Su edad ósea corresponde a 7 años y 10 meses. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Controlar en 6 meses
B Frenar la pubertad
C Solicitar un cariograma
D Solicitar radiografías de huesos largos
E Solicitar niveles plasmáticos de hormona de crecimiento

Respuesta A. La niña está en el percentil 5, por encima de los límites de talla baja (menor de p3 o menos 2 desviaciones estándar), crece con velocidad normal y tiene edad ósea concordante con la cronológica y padres de talla baja, es decir, una variante normal con talla baja familiar. Basta con controlar su crecimiento en 6 meses. No se justifica estudio genético ni de hormona de crecimiento, y frenar la pubertad no tiene indicación.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 80

Un niño de 12 años, con antecedente de un meduloblastoma de fosa posterior, tratado con quimioterapia y radioterapia cerebral, en remisión completa, desde hace 5 años; consulta por talla baja. Su curva de crecimiento demuestra que ha estado creciendo en una talla equivalente al percentil 2 para la edad y, en su examen físico, presenta desarrollo genital en Tanner 3, con vello púbico en Tanner 4. La talla parental estimada es de 170 cm. ¿Cuál es la causa más probable de su talla baja?

A Retraso pubertad
B Recidiva tumoral
C Hipogonadismo
D Déficit de hormona de crecimiento
E Talla baja familiar

Respuesta D. Tiene una talla baja (menor a percentil 3 o -2DS). Tiene desarrollo puberal, así que no es ni retraso puberal ni hipogonadismo. Su talla parental (promedio de talla de madre y padre, ajustada por sexo: se suma 6,5 cm al promedio si el niño tiene sexo masculino y se resta 6,5 cm si tiene sexo femenino) es alta, así que no es TBF. El antecedente de la RT hace que probablemente tenga daño hipofisiario con el déficit de GH, también llamado enanismo.

▶ VER CLASE `2.01.1.077` **Cefalea** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.6 · Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

QUÉ HAY QUE SABER

- Cefalea primaria más frecuente en niños: migraña (bilateral/frontal en niños, pulsátil, náuseas, foto/fonofobia, alivio con sueño, historia familiar) y cefalea tensional (opresiva, sin náuseas).
- Banderas rojas de cefalea secundaria: <3 años, cefalea que despierta o matinal con vómitos, progresiva, cambio de patrón, examen neurológico alterado, papiledema, ataxia, cambio de conducta, aumento de perímetro craneano, fiebre con meningismo.
- Ante banderas rojas: neuroimagen (RM o TC) y derivación urgente (tumor SNC, hipertensión endocraneana, hidrocefalia).
- Crisis migrañosa: ibuprofeno 10 mg/kg o paracetamol 15 mg/kg precoz, reposo en ambiente oscuro; antieméticos si vómitos; evitar uso >2-3 días/semana (cefalea por abuso).

- Medidas: diario de cefalea, sueño regular, hidratación, no saltarse comidas, manejo del estrés; profilaxis (flunarizina, propranolol, amitriptilina) si ≥4 crisis/mes incapacitantes.
- Seguimiento: control en APS con diario; derivar a neurología si banderas rojas, refractaria o requiere profilaxis.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 180

Un paciente de 12 años, consulta por cuadro caracterizado por de visión de destellos hace una hora, tras lo cual evolucionó con cefalea frontotemporal intensa, de tipo pulsátil, asociado a fotofobia y fonofobia. Refiere que desde los cinco años ha presentado cuadros similares, y que durante el último año ha presentado cinco episodios. **El diagnóstico más probable es:**

A Migraña clásica
B Cefalea en racimos
C Cefalea tensional
D Migraña complicada
E Tumor cerebral

Respuesta A. Destellos visuales seguidos de cefalea pulsátil con fotofobia y fonofobia, con episodios similares por años: migraña con aura, llamada clásica. No es tensional (pulsátil, con foto y fonofobia) ni tumor (es recurrente desde hace años, sin progresión ni déficit).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 180

Un paciente de 12 años consulta porque hace una hora presentó visión de destellos, tras lo cual evolucionó con cefalea frontotemporal intensa, de tipo pulsátil, asociada a fotofobia y fonofobia. Refiere que desde los 5 años ha presentado cuadros similares, y durante el último año ha tenido cinco episodios. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Migraña con aura (clásica)
B Cefalea en racimos
C Cefalea tensional
D Migraña complicada
E Tumor cerebral

Respuesta A. Cefalea pulsátil intensa con fotofobia y fonofobia, precedida de aura visual (destellos) que se resuelve antes del dolor, recurrente desde hace años y con examen presumiblemente normal, es migraña con aura. La migraña es la cefalea primaria recurrente más frecuente en niños. La migraña complicada implica déficit persistente; el tumor da cefalea progresiva con signos de alarma.

▶ VER CLASE 2.01.1.078 Encefalopatía hipóxico-isquémica

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.15 · Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

QUÉ HAY QUE SABER

- Encefalopatía hipóxico-isquémica: síndrome neurológico en RN ≥35 semanas tras asfixia perinatal: acidosis (pH <7,0 o déficit de base ≥12 en cordón), Apgar bajo prolongado, necesidad de reanimación.
- Clasificación de Sarnat: I leve (hiperalerta, buen pronóstico), II moderada (letargia, hipotonía, convulsiones), III grave (coma, flacidez, ausencia de reflejos; alta mortalidad y secuelas).
- Compromiso multiorgánico: renal (oliguria), cardíaco, hepático, coagulopatía, hipoglicemia, hipocalcemia, SIADH.
- Manejo inicial: reanimación adecuada, evitar hipertermia, mantener normoglicemia y ventilación, tratar convulsiones (fenobarbital 20 mg/kg EV), restricción hídrica relativa.
- Hipotermia terapéutica (33-34 °C por 72 h) iniciada en <6 h de vida en EHI moderada-grave: trasladar precozmente a centro con UCI neonatal.
- Seguimiento: derivar a neonatología y neurología; seguimiento del neurodesarrollo (parálisis cerebral, epilepsia, déficit cognitivo).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un recién nacido de 39 semanas nace tras un desprendimiento de placenta, con Apgar 2 al minuto y 4 a los 10 minutos, requiriendo ventilación con presión positiva. El pH de cordón es 6,9 con exceso de base -18. A las 2 horas de vida está letárgico, hipotónico, con succión débil y reflejos disminuidos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Observar en puerperio con su madre
B Iniciar hipotermia terapéutica antes de las 6 horas de vida
C Iniciar fenobarbital profiláctico
D Administrar bicarbonato endovenoso en bolo
E Calentar activamente hasta 38 °C

Respuesta B. Asfixia perinatal (evento centinela, Apgar bajo prolongado, acidosis grave de cordón) con encefalopatía moderada a grave en un recién nacido de 36 semanas o más es indicación de hipotermia terapéutica (33 a 34 °C por 72 horas), iniciada antes de las 6 horas de vida, porque reduce muerte y discapacidad.

▶ VER CLASE 2.01.1.079 **Macro y microcefalia** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.1 · Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Medir perímetro craneano en cada control hasta los 2-3 años; macrocefalia >p97 o +2 DE, microcefalia <p3 o -2 DE (grave < -3 DE).
- Macrocefalia: lo más frecuente es familiar benigna (padres con PC grande, desarrollo normal). Patológica: hidrocefalia (fontanela abombada, suturas separadas, ojos en sol poniente, vómitos), colecciones subdurales, megalencefalia.
- Microcefalia: primaria (genética, cromosómica) o secundaria (TORCH, Zika, alcohol fetal, EHI, craneosinostosis, desnutrición grave).
- La curva importa más que un valor aislado: cruzar percentiles hacia arriba o hacia abajo obliga a estudio.
- Estudio inicial: medir PC de los padres, evaluar desarrollo psicomotor; ecografía cerebral si fontanela abierta; TC/RM por especialista.
- Seguimiento: derivar a neurología pediátrica/neurocirugía si crecimiento acelerado, signos de hipertensión endocraneana, retraso del desarrollo o microcefalia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 5 meses, en control sano, tiene un perímetro cefálico que ha cruzado dos carriles de percentil, desde p50 al nacer hasta sobre p98 ahora. La fontanela anterior está amplia y tensa, y presenta mirada en sol poniente. Su desarrollo psicomotor muestra pobre sostén cefálico. **¿Cuál es el examen inicial más adecuado?**

A Radiografía de cráneo
B Ecografía cerebral transfontanelar
C Electroencefalograma
D Medición del perímetro cefálico de los padres y control en 3 meses
E Cariograma

Respuesta B. Macrocefalia progresiva (cruce de percentiles) con fontanela tensa, signo de sol poniente y retraso del desarrollo sugiere hidrocefalia con hipertensión endocraneana. Con fontanela abierta, el examen inicial rápido y sin radiación es la ecografía transfontanelar, seguida de RM. Medir a los padres sirve para la macrocefalia familiar benigna, que crece en su percentil y con desarrollo normal.

▶ VER CLASE 2.01.1.080 **Retraso del desarrollo SM** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.2 · Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Retraso del desarrollo psicomotor: desempeño significativamente bajo lo esperado en ≥1 área (motor grueso, fino, lenguaje, social). Global si ≥2 áreas en <5 años.
- Evaluación en APS: EEDP (0-2 años) y TEPSI (2-5 años); resultado normal, riesgo o retraso. Pauta breve en cada control.
- Banderas rojas: no sostén cefálico a los 4 meses, no sedestación a 9 meses, no marcha a 18 meses, no palabras a 16-18 meses, pérdida de habilidades adquiridas (regresión), asimetría.
- Causas: prematurez, EHI, genéticas (síndrome de Down, X frágil), TORCH, hipotiroidismo, déficit sensorial (hipoacusia, visión), TEA, deprivación psicosocial.
- Manejo inicial: estimulación en sala de estimulación (Chile Crece Contigo), evaluar audición y visión, TSH, reevaluar en 3 meses.
- Seguimiento: derivar a neurología si retraso persistente, regresión o examen neurológico alterado; kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 10 meses, nacido a las 36 semanas de gestación, es traído a su control de salud pendiente de los 8 meses. Al examen no logra sentarse sin apoyo, no transfiere objetos entre sus manos, y solo emite sonidos guturales aislados. Se le aplica la EEDP y obtiene un puntaje de 65 puntos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Reforzar pautas de estimulación y controlar según calendario habitual
B Derivar a sala de estimulación y reevaluar con EEDP en 60 días
C Realizar examen neurológico y derivar a pediatría o neurología infantil
D Calcular su edad corregida por la prematurez y tranquilizar a la familia
E Indicar control telefónico en 6 meses

Respuesta C. Un puntaje de 65 puntos en la EEDP corresponde a retraso del desarrollo psicomotor (< 70 puntos), que exige evaluación médica y derivación inmediatas. La prematurez de 36 semanas es leve y la edad corregida no alcanza a explicar un retraso de esta magnitud a los 10 meses.

▶ VER CLASE 2.01.1.081 **Síndrome convulsivo** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.14 · Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Convulsión febril simple: 6 meses-5 años, generalizada, <15 min, única en 24 h, sin focalidad ni déficit postictal, con fiebre sin infección del SNC. Compleja: focal, >15 min o repetida en 24 h.

- Convulsión febril simple no requiere EEG, neuroimagen ni exámenes de rutina; punción lumbar si signos meníngeos, <12 meses sin vacunas al día o antibiótico previo.
- Crisis activa >5 min: diazepam 0,3-0,5 mg/kg rectal o midazolam 0,2-0,3 mg/kg bucal/intranasal/IM, o lorazepam/diazepam EV; ABC, posición lateral, O2, glicemia.
- Epilepsia: ≥2 crisis no provocadas separadas >24 h; EEG y RM. Epilepsia en <15 años es GES. Ausencias típicas: crisis breves con detención, desencadenadas por hiperventilación, EEG punta-onda 3 Hz.
- Antipiréticos no previenen recurrencia; recurrencia de convulsión febril ~30%; riesgo de epilepsia levemente aumentado solo en las complejas.
- Seguimiento: convulsión febril simple se controla en APS con educación familiar; derivar a neurología si crisis afebriles, focales, complejas o epilepsia.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 18 meses, previamente sano y con vacunas al día. Con fiebre de 39,2 °C por una faringoamigdalitis, presenta una crisis tónico-clónica generalizada, de 3 minutos, que cede sola. Veinte minutos después está afebril, activo, reactivo, se conecta con sus padres, sin rigidez de nuca ni déficit motor. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Diagnosticar convulsión febril simple, tratar el foco infeccioso y educar a los padres

B Solicitar electroencefalograma antes del alta

C Hospitalizar en UCI para iniciar fenitoína

D Realizar punción lumbar de urgencia

E Iniciar ácido valproico profiláctico

Respuesta A. Edad típica, crisis generalizada breve y única, recuperación completa sin signos meníngeos: es una convulsión febril simple. No requiere EEG, punción lumbar ni fármaco de mantención; se trata el foco infeccioso y se educa a los padres.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 21

Un niño de 7 años presenta episodios en los que se queda quieto, mirando fijo, los que luego no recuerda. Han aumentado en frecuencia, hasta suceder 5 veces al día. El resto de su examen físico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Síncompes vasovagales

B Epilepsia mioclónico

C Crisis de ausencia

D Epilepsia focal

E Déficit atencional

Respuesta C. Diagnóstico: Crisis de ausencia (opción C). Cuadro clásico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 78

Un niño de 7 años es traído por su madre, porque presenta mal rendimiento escolar. Tiene un hermano con déficit atencional diagnosticado. Durante el examen, presenta un breve episodio de desconexión con el medio. ¿Con que examen se debe continuar el estudio de este paciente?

A Psicometría

B Evaluación psicopedagógica

C Electroencefalograma

D TAC cerebral

E Audiometría

Respuesta C. Tiene una probable epilepsia por crisis de ausencia. Se estudia con EEG, al igual que las demás epilepsias primarias. Su hermano también debería estudiarse.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 77

Un niño de 10 años convulsiona a la mañana siguiente, de haber trasnochado jugan- do videojuegos. Además refiere mioclonías matinales frecuentes, desde hace algunos meses. Su examen físico es normal, al igual que su examen neurológico. ¿Cuál es la me- dida más adecuada?

A Prohibir por completo los videojuegos

B Iniciar ácido valproico

C Iniciar carbamazepina

D Iniciar fenobarbital

E Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro

Respuesta B. Es una probable epilepsia mioclónica, que se trata preferentemente con ácido val- proico. Sí pueden jugar videojuegos, pero con pantallas e iluminación adecuadas y por ciertos horarios limitados. Es una pregunta que excede los conocimientos de un médico general.

▶ VER CLASE | 2.01.1.082 | **Síndrome déficit atencional** | DX ESPECÍFICO | TX INICIAL | SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.18 · Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- TDAH: trastorno del neurodesarrollo; ≥6 síntomas de inatención y/o hiperactividad-impulsividad por ≥6 meses (≥5 en ≥17 años), varios presentes antes de los 12 años.

- Requisito clave: síntomas en ≥2 contextos (casa y colegio) con deterioro académico o social; si solo ocurre en un ambiente no es TDAH. Usar cuestionarios de padres y profesores (Conners).
- Presentaciones: combinada (la más frecuente), inatenta (más en niñas, pasa desapercibida) e hiperactiva-impulsiva. Descartar hipoacusia, déficit visual, trastorno de aprendizaje, ansiedad, depresión, apnea del sueño, maltrato.
- Tratamiento multimodal: psicoeducación a familia, manejo conductual, apoyo escolar (PIE); fármaco de primera línea metilfenidato (acción corta o prolongada) en ≥6 años.
- Efectos adversos del metilfenidato: hiporexia (controlar peso y talla), insomnio de conciliación, cefalea, leve taquicardia/alza de PA.
- Seguimiento: derivar a neurología o psiquiatría infantil para confirmar diagnóstico e iniciar fármaco; control periódico de peso, talla y PA.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 7 años es derivado por su profesora porque no termina sus tareas, se distrae, se levanta constantemente y interrumpe en clases desde hace un año. Los padres refieren que en la casa es igual: pierde sus cosas, no espera turnos y no logra jugar tranquilo. **Para diagnosticar trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿qué elemento es indispensable?**

A Un electroencefalograma alterado

B Una resonancia magnética cerebral alterada

C Síntomas presentes en dos o más contextos, por al menos 6 meses, con inicio antes de los 12 años

D Una respuesta positiva a una prueba con metilfenidato

E Rendimiento escolar insuficiente en todas las asignaturas

Respuesta C. El diagnóstico de TDAH es clínico (DSM-5): síntomas de inatención y/o hiperactividad-impulsividad persistentes por 6 meses o más, presentes en al menos dos ambientes (casa y colegio), iniciados antes de los 12 años y con deterioro funcional, no explicados por otro trastorno. No requiere exámenes. La respuesta al metilfenidato no confirma el diagnóstico.

▶ VER CLASE 2.01.1.083 Síndrome hipertónico

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.2 · Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome hipertónico: aumento del tono muscular por lesión de primera motoneurona; espasticidad (velocidad-dependiente, hiperreflexia, clonus, Babinski persistente) o distonía/rigidez.
- Causa más frecuente: parálisis cerebral (lesión encefálica no progresiva): factores de riesgo prematurez, EHI, infecciones congénitas, kernicterus.
- Signos de alerta en lactante: puños cerrados persistentes después de los 3-4 meses, pulgar incluido, hiperextensión, piernas en tijera, preferencia manual antes de los 12-18 meses, persistencia de reflejos primitivos.
- Distinguir hipertonía fisiológica del RN (flexora) y no confundir con hipertonía transitoria del prematuro.
- Manejo inicial: kinesioterapia y estimulación precoz, evaluación de audición, visión y deglución; buscar regresión (sugiere enfermedad neurodegenerativa).
- Seguimiento: derivar a neurología pediátrica y rehabilitación (Teletón); toxina botulínica o cirugía por especialista.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 159

Un niño de 18 meses de edad, con antecedente de haber nacido prematuro de 32 semanas, camina en punta de pies. Logró la marcha independiente hace un mes. Al examen físico tiene aumento del tono muscular de las extremidades inferiores, con hiperreflexia y signo de Babinski. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Estereotipia de la marcha

B Retraso del desarrollo psicomotor

C Diplejía espástica

D Polineuropatía

E Distrofia muscular

Respuesta C. Un exprematuro con hipertonía, hiperreflexia y Babinski predominantes en extremidades inferiores, con marcha en punta de pies, tiene una parálisis cerebral de tipo diplejía espástica, típica de la leucomalacia periventricular del prematuro. La marcha en punta aislada puede ser normal antes de los 3 años, pero no con signos de primera motoneurona. Las polineuropatías y distrofias dan hiporreflexia.

▶ VER CLASE 2.01.1.084 Síndrome hipotónico

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.2 · Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome hipotónico (lactante flácido): postura en rana, poco tono axial, cabeza que cae en la tracción, deslizamiento en suspensión vertical.
- Central (70-80%): hipotonía con fuerza conservada, reflejos normales o vivos, compromiso de conciencia o retraso global; causas: EHI, síndrome de Down, Prader-Willi, hipotiroidismo, sepsis, metabólicas.
- Periférica: debilidad marcada, arreflexia, fasciculaciones linguales (atrofia muscular espinal), sin compromiso cognitivo; causas: AME, miopatías, distrofia miotónica congénita, botulismo del lactante, miastenia.
- Estudio inicial: glicemia, electrolitos, TSH/T4, CK, cariotipo si dismorfias; evaluar deglución y función respiratoria.
- Banderas rojas: dificultad respiratoria, trastorno de deglución, progresión, debilidad con arreflexia: hospitalizar.

- Seguimiento: derivar a neurología pediátrica; kinesioterapia; AME tiene terapias específicas (nusinersen, terapia génica) por especialista.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 4 meses es traído porque no sostiene la cabeza. Al examen está alerta y sigue con la mirada, pero tiene hipotonía generalizada marcada, con postura en batracio, arreflexia osteotendínea, respiración paradojal abdominal y fasciculaciones de la lengua. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Atrofia muscular espinal
B Síndrome de Down
C Hipotiroidismo congénito
D Parálisis cerebral hipotónica
E Síndrome de Prader-Willi

Respuesta A. Hipotonía con debilidad marcada, arreflexia y fasciculaciones linguales, en un lactante alerta y con buena conexión, indica hipotonía periférica por compromiso de la segunda motoneurona: atrofia muscular espinal tipo 1. La hipotonía central (Down, Prader-Willi, parálisis cerebral, hipotiroidismo) conserva o aumenta los reflejos y suele asociar compromiso de conciencia o del desarrollo cognitivo.

▶ VER CLASE 2.01.1.085 Trastornos aprendizaje

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.18 · Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno específico del aprendizaje: dificultad persistente (≥6 meses) en lectura (dislexia), escritura (disortografía) o cálculo (discalculia), con rendimiento bajo lo esperado y CI normal.
- Sospechar en escolar con bajo rendimiento, lectura lenta con errores, inversiones de letras persistentes después de 2º básico, frustración y problemas conductuales secundarios.
- Descartar primero: déficit visual y auditivo, TDAH (comorbilidad frecuente), discapacidad intelectual, depresión/ansiedad, problemas familiares, ausentismo.
- Evaluación: psicopedagógica y psicométrica (descartar discapacidad intelectual); en el colegio, Programa de Integración Escolar (PIE) con adecuaciones curriculares.
- Manejo inicial: apoyo psicopedagógico, comunicación con el colegio, apoyo emocional y refuerzo positivo; no hay fármacos para el trastorno de aprendizaje en sí.
- Seguimiento: derivar a psicopedagogía, neurología o psiquiatría infantil si hay comorbilidad (TDAH) o sospecha de discapacidad intelectual.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 87

Un niño de 7 años perdió el año escolar. Presenta dificultades en la lectoescritura, invierte fonemas con frecuencia, es muy lento para leer y le cuesta deletrear. Su padre no terminó el colegio porque tenía problemas similares. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Coeficiente intelectual limítrofe
B Trastorno oposicionista desafiante
C Trastorno por déficit atencional
D Dislexia
E Trastorno del desarrollo

Respuesta D. Dificultad específica y persistente en la lectura (lenta, con inversiones y errores de decodificación) y en el deletreo, con antecedente familiar, corresponde a dislexia, el trastorno específico del aprendizaje más frecuente. Su base es fonológica y tiene fuerte componente hereditario. El TDAH afecta el rendimiento global por inatención, no específicamente la decodificación lectora.

▶ VER CLASE 2.01.1.086 Trastornos del lenguaje

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.2 · Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Hitos de lenguaje: balbuceo 6 meses, primeras palabras 12 meses, ≥50 palabras y frases de 2 palabras a los 24 meses, frases de 3 palabras y 75% inteligible a los 3 años.
- Banderas rojas: no balbucea a los 12 meses, no dice palabras a los 16-18 meses, no frases a los 24 meses, regresión del lenguaje a cualquier edad, no responde a su nombre.
- Primera causa a descartar: hipoacusia (siempre pedir evaluación auditiva). Otras: trastorno del espectro autista (déficit social, conductas repetitivas), discapacidad intelectual, deprivación, trastorno específico del lenguaje.
- Dislalias (sustitución de fonemas) y tartamudez fisiológica son frecuentes en preescolares; tartamudez persistente >6 meses o después de los 5 años se deriva.
- Manejo inicial: estimulación del lenguaje en casa (leer, hablar, menos pantallas), audiometría/potenciales evocados, M-CHAT si se sospecha TEA (16-30 meses).
- Seguimiento: derivar a fonoaudiología, ORL y neurología/psiquiatría infantil según causa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 2 años es traído porque solo dice 2 palabras. Comprende instrucciones simples cuando lo miran, mantiene contacto visual, juega de forma simbólica y señala lo que quiere. Tuvo varias otitis medias el último año. Su examen físico y el resto del desarrollo son normales. **¿Cuál es el primer examen a solicitar?**

A Resonancia magnética cerebral

B Cariograma

C Electroencefalograma

D Evaluación auditiva (audiometría o potenciales evocados auditivos)

E Test de detección de autismo como único estudio

Respuesta D. A los 2 años se espera un vocabulario de unas 50 palabras y frases de 2 palabras. Ante todo retraso del lenguaje, el primer paso es descartar hipoacusia con una evaluación auditiva objetiva, más aún con otitis a repetición (otitis media con efusión). La buena interacción social y el juego simbólico hacen menos probable un trastorno del espectro autista.

▶ VER CLASE 2.01.1.087 Tumores SNC

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.18 · Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumores del SNC: tumores sólidos más frecuentes en niños (2º cáncer infantil); la mayoría infratentoriales (fosa posterior) entre 1-10 años: meduloblastoma, astrocitoma pilocítico, ependimoma, glioma de tronco.
- Clínica: hipertensión endocraneana (cefalea matinal, vómitos en proyectil, papiledema), ataxia, nistagmo, compromiso de pares craneanos, macrocefalia en lactantes, cambios conductuales.
- Craneofaringioma: alteraciones visuales (hemianopsia bitemporal), talla baja, diabetes insípida.
- Neuroimagen urgente (RM de elección; TC si no disponible) ante cefalea con banderas rojas o examen neurológico alterado.
- Manejo inicial: dexametasona si edema cerebral sintomático, manejo de hipertensión endocraneana (cabeza a 30°), anticonvulsivantes si crisis.
- Cáncer infantil es GES: derivar con urgencia a neurocirugía y oncología pediátrica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 96

Un niño de 9 años, con antecedente de neurofibromatosis tipo 1, consulta por proptosis izquierda de 6 meses de evolución, progresiva e indolora. Tenía un examen visual normal a los 6 años. Actualmente se observa proptosis izquierda leve, con disminución de la visión de colores del ojo izquierdo y agudeza visual 20/25 en el ojo derecho y 20/30 en el ojo izquierdo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Celulitis orbitaria

B Retinoblastoma

C Orbitopatía distiroidea

D Angiolipoma orbitario

E Tumor del nervio óptico

Respuesta E. La neurofibromatosis tipo 1 se asocia a glioma de la vía óptica, el tumor del SNC más característico de esta enfermedad. Proptosis unilateral progresiva e indolora con alteración de la visión de colores (disfunción del nervio óptico) orienta a glioma del nervio óptico. Se estudia con resonancia de órbitas y cerebro. La celulitis orbitaria es aguda, dolorosa y febril.

▶ VER CLASE 2.01.1.088 Criptorquidia

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.7 · Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes

QUÉ HAY QUE SABER

- Criptorquidia: testículo no descendido en el escroto; 3% en RN de término, 30% en prematuros; la mayoría desciende en los primeros 3-6 meses.
- Diferenciar de testículo retráctil (desciende con maniobra y permanece en el escroto, normal) y ascendido.
- Palpable vs no palpable: no palpable bilateral o con hipospadias obliga a descartar desarrollo sexual diferente (hiperplasia suprarrenal congénita en niña virilizada). La ecografía no es necesaria para decidir.
- Tratamiento: orquidopexia entre los 6 y 18 meses (idealmente antes del año); la terapia hormonal no se recomienda.
- Riesgos de no tratar: infertilidad, cáncer testicular (seminoma), torsión y hernia inguinal asociada.
- Seguimiento: derivar a cirugía infantil desde los 6 meses; controlar posición testicular en cada control y autoexamen testicular en adolescencia.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 116

Usted evalúa a un recién nacido de término, en buenas condiciones, que se alimenta con leche materna y tiene examen neurológico normal. Al examen físico segmentario no se palpa ninguno de los testículos en el escroto ni en la zona inguinal. Su pene mide 2 cm de largo. **Además de solicitar una ecografía inguinal, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Controlar en un mes
B Solicitar niveles plasmáticos de testosterona
C Realizar exploración quirúrgica inmediata mediante laparoscopía
D Solicitar cariograma
E Planificar cirugía de descenso testicular al cumplir un año

Respuesta D. Criptorquidia bilateral no palpable, sobre todo con pene pequeño, es una alteración de la diferenciación sexual hasta demostrar lo contrario: puede ser una recién nacida 46,XX virilizada por hiperplasia suprarrenal congénita (con riesgo de crisis perdedora de sal). Requiere cariograma urgente (y 17-OH-progesterona y electrolitos). Controlar en un mes es adecuado solo para la criptorquidia unilateral aislada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 20

Recién nacido de término sin testículos palpables, pene de 2 cm. Además de solicitar ecografía, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A Derivar a urología de inmediato
B Control en un mes
C Iniciar testosterona tópica
D Derivar a genética para cariotipo urgente
E Cirugía correctiva a los 3 meses

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Control en un mes (opción B). Control en un mes.

▶ VER CLASE 2.01.1.089 Fimosis

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.27 · Uroginecología Pediátrica: Fimosis, Sinequias Vulvares y Enuresis

QUÉ HAY QUE SABER

- Fimosis fisiológica: prepucio no retráctil, normal hasta los 3-5 años y presente en ~10% a los 6 años; adherencias balanoprepuciales normales.
- Fimosis patológica: anillo fibroso cicatricial blanquecino (balanitis xerótica obliterante), balanitis o ITU recurrentes, abombamiento del prepucio al orinar con chorro débil.
- No retraer el prepucio a la fuerza (fisuras, cicatrices, parafimosis); higiene suave en baño.
- Tratamiento: corticoide tópico (betametasona 0,05-0,1%) 2 veces al día por 4-8 semanas con retracción suave; si falla, circuncisión.
- Parafimosis: prepucio retraído que no vuelve, edema del glande: urgencia; reducción manual con compresión y lubricación, si falla derivar.
- Seguimiento: derivar a cirugía infantil si fimosis patológica, falla de corticoide, ITU recurrente o balanitis a repetición.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 21

Niño de 3 años con prepucio estrecho que no permite retraerlo completamente. Logró el control de esfínteres hace 6 meses. No ha tenido infecciones urinarias, balanitis ni dificultad miccional. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Circuncisión inmediata
B Aplicar corticoide tópico
C Control en un año
D Dilatación manual bajo anestesia
E Derivar a urología pediátrica urgente

Respuesta C. La fimosis es fisiológica en la mayoría de los niños pequeños: el prepucio se va despegando espontáneamente y suele ser retráctil entre los 3 y 5 años o más. Sin complicaciones (balanitis, ITU, obstrucción miccional), la conducta es observar y no retraer a la fuerza. Los corticoides tópicos se usan si persiste más allá de esa edad o es sintomática.

▶ VER CLASE 2.01.1.090 Hernia inguinal

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.6 · Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones

QUÉ HAY QUE SABER

- Hernia inguinal pediátrica: indirecta (persistencia del conducto peritoneo-vaginal), más frecuente en varones, prematuros y lado derecho.
- Clínica: aumento de volumen inguinal o inguinoescrotal intermitente que aumenta con llanto o esfuerzo; diagnóstico clínico (signo de la seda).
- Diferenciar de hidrocele comunicante (transiluminación positiva, varía de tamaño; observar hasta 1-2 años) y no comunicante.
- Hernia atascada: masa dolorosa irreductible, irritabilidad, vómitos; intentar reducción manual con analgesia si <12 h y sin signos de estrangulación; luego cirugía en 24-48 h.
- Estrangulación (eritema, fiebre, vómitos biliosos, compromiso general): cirugía de urgencia. Riesgo de atascamiento mayor en <1 año y prematuros.

- Seguimiento: derivar a cirugía infantil para herniotomía electiva precoz en todo niño con hernia inguinal; en lactantes, cirugía programada a la brevedad.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 3

Recién nacido de 3 días con protuberancia blanda en la línea media abdominal, de 1 centímetro de diámetro, reductible, sin signos inflamatorios. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Cirugía electiva inmediata
B Cirugía de urgencia
C Derivación a cirugía pediátrica urgente
D Antibióticos profilácticos
E Observación: la mayoría se cierra sola antes de los 4 años

Respuesta E. La hernia umbilical del recién nacido es fisiológica y se cierra espontáneamente en la gran mayoría de los casos antes de los 4 años. No requiere cirugía ni antibióticos mientras sea reductible y sin signos inflamatorios.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 3 meses, nacido de término, presenta un aumento de volumen inguinal derecho que aparece con el llanto y desaparece en reposo. Al examen la tumoración es blanda, reductible e indolora, y no transilumina. El testículo derecho está en el escroto. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Observar hasta los 2 años, porque suele cerrarse espontáneamente
B Puncionar para descartar hidrocele
C Indicar braguero
D Cirugía solo si se atasca
E Cirugía electiva precoz (herniotomía) en los próximos días a semanas

Respuesta E. La hernia inguinal pediátrica es indirecta, por persistencia del conducto peritoneovaginal, y no se cierra sola. Por el alto riesgo de atascamiento en lactantes debe operarse en forma electiva y precoz, apenas se diagnostica. A diferencia de la hernia umbilical y el hidrocele comunicante, no se observa. El braguero no está indicado y la punción está contraindicada.

▶ VER CLASE 2.01.1.091 Alteraciones de los pies

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.14 · Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Pie plano flexible: normal hasta los 6-8 años, arco aparece al ponerse en puntillas; asintomático no requiere tratamiento ni plantillas.
- Pie plano rígido o doloroso (coalición tarsal, astrágalo vertical): derivar.
- Metatarso aducto: antepié en aducción con borde lateral convexo; flexible se corrige solo o con elongación; rígido: yesos.
- Pie bot (equino varo congénito): equino, varo, aducto y cavo rígido; tratamiento con método de Ponseti (yesos seriados desde las primeras semanas, tenotomía y férula). Buscar displasia de caderas asociada.
- Marcha en puntillas persistente >3 años o asimétrica: descartar parálisis cerebral, distrofia muscular, TEA; marcha con pies hacia dentro suele ser por anteversión femoral o torsión tibial y se corrige espontáneamente.
- Seguimiento: derivar a traumatología infantil pie bot, pie plano rígido/doloroso, metatarso aducto rígido y alteraciones asimétricas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de término, de 2 días de vida, en puerperio. Al examen, el pie derecho está en equino, varo, aducto y cavo, con un pliegue medial profundo, y no se logra llevar a posición neutra con la manipulación suave. El resto del examen, incluidas caderas y columna, es normal. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?**

A Pie metatarso aducto postural; observar y tranquilizar
B Pie bot; esperar hasta el año de vida para cirugía
C Pie plano flexible; plantillas desde el inicio de la marcha
D Pie talo valgo; ejercicios de elongación por los padres
E Pie bot (equinovaro congénito); derivar precozmente a traumatología infantil para tratamiento con método de Ponseti (yesos seriados)

Respuesta E. El pie bot o equinovaro congénito tiene equino, varo, aducto y cavo rígidos, que no se corrigen con la manipulación. Debe derivarse en las primeras semanas para el método de Ponseti con yesos seriados, habitualmente con tenotomía del Aquiles y férula de abducción. Las deformidades posturales, en cambio, se corrigen pasivamente.

▶ VER CLASE 2.01.1.092 Displasia de caderas

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.22 · Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik

QUÉ HAY QUE SABER

- Displasia del desarrollo de caderas: factores de riesgo sexo femenino, primogénito, presentación podálica, antecedente familiar, oligoamnios, otras deformidades (tortícolis, pie bot).

- Examen en RN y controles: maniobras de Ortolani (reduce, signo de salida) y Barlow (luxa) hasta los 3 meses; luego limitación de abducción, asimetría de pliegues, signo de Galeazzi, acortamiento.
- Tamizaje GES: radiografía de pelvis AP a los 3 meses a todos los lactantes (índice acetabular, líneas de Hilgenreiner y Perkins, cuadrantes de Putti); ecografía de cadera antes de los 3 meses si hay factores de riesgo o examen alterado.
- Diagnóstico tardío (marcha): cojera, marcha de Trendelenburg, hiperlordosis en displasia bilateral.
- Tratamiento inicial: no usar doble pañal (no tiene evidencia); el especialista indica arnés de Pavlik (<6 meses), reducción cerrada con yeso o cirugía según edad.
- Seguimiento: derivar a traumatología infantil toda sospecha clínica o radiológica; displasia de caderas es GES.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 34

Lactante de 2 meses, con lactancia materna exclusiva y buen incremento de peso, presenta signo de Ortolani y limitación en la abducción de la cadera derecha. Sin antecedentes familiares. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar ecografía de caderas

B Solicitar resonancia magnética de caderas

C Indicar doble pañal y control en un mes

D Realizar radiografía anteroposterior de pelvis de rutina a los 3 meses

E Realizar cirugía

Respuesta A. Ante un Ortolani positivo antes de los 3 meses, el examen de elección es la ecografía de caderas, porque el núcleo femoral todavía es cartilaginoso y no se ve en radiografía. Esperar a la radiografía de los 3 meses retrasaría la derivación de un hallazgo ya positivo.

▶ VER CLASE 2.01.1.093 **Infecciones osteoarticulares** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.2 · Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos

QUÉ HAY QUE SABER

- Artritis séptica: urgencia; fiebre, articulación caliente, dolorosa, con impotencia funcional (cadera en flexión, abducción y rotación externa, pseudoparálisis en lactante). S. aureus el principal agente; Kingella kingae en <4 años.
- Criterios de Kocher (cadera): fiebre >38,5 °C, no apoyo, VHS >40 mm/h, leucocitos >12.000 (PCR >2 mg/dL): ≥3 alta probabilidad. Diferencial: sinovitis transitoria (post viral, afebril, buen estado).
- Osteomielitis aguda hematógena: metáfisis de huesos largos, dolor localizado, fiebre, cojera; Rx inicial normal (cambios a los 10-14 días), RM de elección; hemocultivos.
- Estudio: hemograma, VHS, PCR, hemocultivos, ecografía de cadera (derrame) y artrocentesis (>50.000 leucocitos con PMN, Gram y cultivo).
- Manejo inicial: hospitalizar, hemocultivos y cloxacilina o cefazolina EV (+ clindamicina/vancomicina si SAMR); artritis séptica requiere drenaje quirúrgico urgente.
- Seguimiento: derivar a traumatología infantil; completar antibiótico 3-4 semanas (artritis) o 4-6 semanas (osteomielitis) con PCR seriada.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 105

Una niña de 5 años presenta dolor en muslo izquierdo, que luego se ubica en la cadera izquierda y que limita su movimiento. Al examen físico está en buenas condiciones. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A Sinovitis transitoria

B Atritis séptica

C Artritis reumatoidea

D Osteomielitis

E Tumor de Ewing

Respuesta A. Aunque la sinovitis transitoria suele ser en menores de 5 años, la clínica es compatible, porque la niña está en buenas condiciones.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 94

Un niño de 6 años consulta por dolor en el codo derecho de dos días de evolución, asociado a impotencia funcional y fiebre de hasta 39 °C. Al examen físico se observa el codo eritematoso y aumentado de volumen, con dolor intenso a la movilización activa y pasiva. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Staphylococcus aureus

B Haemophilus influenzae

C Streptococcus agalactiae

D Neisseria meningitidis

E Streptococcus pyogenes

Respuesta A. Monoartritis aguda febril con dolor a la movilización activa y pasiva en un niño es artritis séptica hasta demostrar lo contrario. El agente más frecuente a toda edad pediátrica es Staphylococcus aureus (además Kingella kingae en menores de 4 años). El Haemophilus prácticamente desapareció con la vacuna. Requiere artrocentesis, drenaje y antibióticos endovenosos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 142

Lactante de 6 meses, es traída por cuadro de 48 horas de evolución caracterizado por rechazo alimentario, irritabilidad y decaimiento, asociado a inmovilidad de extremidad inferior izquierda. Al examen se encuentra con temperatura de 38,5ºC y se aprecia cadera izquierda en flexión, con mucho dolor a la movilización. El examen inicial más adecuado en este caso es:

A Hemograma con VHS
B Radiografía de pelvis
C Ecografía de cadera
D Cintigrafía ósea
E Resonancia magnética de cadera

Respuesta A. Tiene una artritis séptica, por lo que la respuesta debería ser punción. La pregunta es capciosa. Que diga "examen inicial" hace orientar más al hemograma. Esta niña probablemente irá directo a pabellón. La Eco sirve para guiar la punción. No estoy seguro de cuál es la respuesta correcta.

▶ VER CLASE 2.01.1.094 Patología de columna

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.14 · Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Escoliosis idiopática del adolescente: la más frecuente, predominio femenino en estirón puberal; tamizaje con test de Adams (giba costal al inclinarse) y escoliómetro.
- Confirmar con radiografía de columna total de pie AP y lateral: escoliosis si ángulo de Cobb ≥10°; idiopática típicamente torácica derecha e indolora.
- Manejo por Cobb y madurez (Risser): <20-25° observación con controles radiológicos cada 4-6 meses; 25-40-45° en crecimiento: corsé; >45-50°: cirugía. Escoliosis idiopática <25 años es GES (cirugía).
- Banderas rojas de escoliosis secundaria: dolor, curva torácica izquierda, progresión rápida, déficit neurológico, manchas café con leche (neurofibromatosis), alteraciones cutáneas lumbosacras: RM.
- Dolor lumbar en niño no es habitual: descartar espondilolisis (deportistas en hiperextensión), espondilodiscitis, tumores (osteoma osteoide: dolor nocturno que cede con AINE), Scheuermann (cifosis rígida).
- Seguimiento: derivar a traumatología infantil escoliosis ≥20° o con banderas rojas; control en APS de curvas menores.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 132

En el examen físico de un recién nacido se evalúa la región lumbosacra en busca de marcadores cutáneos de disrafia espinal. **¿Qué alteración del examen físico obliga a descartar una disrafia espinal de tipo espina bífida oculta?**

A Melanocitosis dérmica congénita (mancha mongólica)
B Nevus flammeus sacro
C Nevo congénito pequeño en la zona sacra
D Hoyuelo sacro o fosita pilonidal típica
E Seno dérmico sacrococcígeo

Respuesta E. Un seno dérmico (trayecto que comunica la piel con planos profundos, sobre la zona sacra alta o lumbar) obliga a estudiar disrafia espinal oculta y médula anclada, y tiene riesgo de meningitis. Otros marcadores son hipertricosis localizada, lipoma o hemangioma lumbosacro. La fosita pilonidal simple, baja y con fondo visible, y la mancha mongólica son hallazgos benignos.

▶ VER CLASE 2.01.1.095 Conjuntivitis aguda

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.2 · Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Conjuntivitis aguda: ojo rojo con secreción, sin dolor intenso, visión y pupilas normales.
- Bacteriana: secreción purulenta, párpados pegados al despertar; tratar con colirio antibiótico (tobramicina o cloranfenicol, ungüento en lactantes) por 5-7 días. Asociada a otitis media (síndrome conjuntivitis-otitis por H. influenzae): amoxicilina-ácido clavulánico oral.
- Viral (adenovirus): secreción acuosa, folículos, adenopatía preauricular, muy contagiosa; manejo con frío local, lágrimas artificiales y lavado de manos. Alérgica: prurito, bilateral, antecedentes atópicos; antihistamínicos tópicos.
- Neonatal: <24 h química; 2-5 días gonocócica (hiperaguda, purulenta: ceftriaxona sistémica, urgencia); 5-14 días Chlamydia (azitromicina o eritromicina oral).
- No usar corticoides tópicos en atención primaria.
- Seguimiento: derivar a oftalmología si dolor, fotofobia, disminución de visión, opacidad corneal, conjuntivitis neonatal o falta de respuesta en 7 días.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 32

Un recién nacido de 20 días de vida, cuyo embarazo no fue controlado y que nació por parto vaginal en su casa, es traído por presentar secreción ocular bilateral desde hace 5 días. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival y escasa secreción bilateral. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Neisseria meningitidis
B Neisseria gonorrhoeae
C Streptococcus pneumoniae
D Streptococcus agalactiae
E Chlamydia trachomatis

Respuesta E. El gonococo y la clamidia son las dos causas clásicas de conjuntivitis neonatal, pero se distinguen por el tiempo de aparición y la intensidad: el gonococo es muy purulento y aparece en la primera semana; la clamidia demora más, entre una y tres semanas, y es menos purulenta. Con 20 días de vida y secreción escasa, la clamidia es más probable que el gonococo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 32

Un recién nacido de 20 días, cuyo embarazo no fue controlado y que nació por parto vaginal en su casa, es traído por secreción ocular bilateral desde hace 5 días. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival y escasa secreción bilateral. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Neisseria meningitidis
B Neisseria gonorrhoeae
C Streptococcus pneumoniae
D Streptococcus agalactiae
E Chlamydia trachomatis

Respuesta E. La conjuntivitis neonatal por Chlamydia trachomatis aparece entre los 5 y 14 días de vida o después, con secreción escasa o moderada, y puede asociarse a neumonía afebril. La gonocócica aparece antes (2 a 5 días) con secreción purulenta abundante y riesgo de perforación corneal. Se trata con azitromicina o eritromicina oral, y deben tratarse los padres.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 22

Niño con fiebre, odinofagia, ojo rojo bilateral y conjuntivitis. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A Aseo ocular con suero fisiológico
B Colirio antibiótico tópico
C Aciclovir oftálmico
D Azitromicina oral
E Clorfenamina oral

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Aseo ocular con suero fisiológico (opción A). Aseo ocular con suero fisiológico. Ante cualquier signo de alarma, la conducta del médico general es derivar de urgencia al oftalmólogo sin intentar manejo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 123

Un niño de 4 años presenta sensación febril y ojo rojo bilateral, asociado a ardor y lagrimeo, lo que se acompaña de rinorrea y odinofagia. Varios de sus familiares tienen los mismos síntomas. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A Chlamydia trachomatis
B Staphilococcus aureus
C Streptococcus pyogenes
D Haemophilus influenzae
E Adenovirus

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Adenovirus). Es una fiebre faringoconjuntival clásica por ADV. El ojo rojo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica del médico general.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 10

Un prescolar de 4 años presenta un cuadro de una semana de evolución de fiebre, hasta 39°C, asociada a odinofagia. Además, se ha asociado ojo rojo, que inició en el lado izquierdo y al día siguiente se extendió al ojo derecho. Al examen físico, tiene faringe eritematosa, ojo rojo bilateral, con secreción mucosa escasa y se palpan adenopatías cervicales bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de sus síntomas oculares?

A Aseo con suero fisiológico
B Corticoide tópico
C Ungüento de tobramicina
D Colirio de gentamicina
E Ungüento de cloramfenicol

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Ungüento de cloramfenicol (opción E). Ante cualquier signo de alarma, la conducta del médico general es derivar de urgencia al oftalmólogo sin intentar manejo.

▶ VER CLASE 2.01.1.096 Estrabismo

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Oftalmología 15.9 · Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Estrabismo: desalineación ocular; normal intermitente hasta los 4-6 meses. Persistente o constante después de esa edad es patológico.
- Evaluar con reflejo corneal de Hirschberg y cover test; diferenciar pseudoestrabismo (epicanto, puente nasal ancho, reflejo corneal simétrico).
- Endotropia (desviación nasal) la más frecuente; endotropia acomodativa en hipermétropes a los 2-3 años, se corrige con lentes.
- Riesgo principal: ambliopía (ojo vago), tratable hasta los 7-8 años con oclusión del ojo sano y corrección óptica; luego es irreversible.
- Banderas rojas: estrabismo de inicio súbito, con leucocoria (retinoblastoma), paresia de nervios craneanos, cefalea o signos de hipertensión endocraneana.
- Seguimiento: derivar a oftalmología infantil todo estrabismo persistente después de los 6 meses; estrabismo en <9 años es GES.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 115

Un lactante de 1 mes acude a control. Al examen físico presenta estrabismo intermitente y asimétrico de ambos ojos. El resto de la inspección ocular es normal, incluido el rojo pupilar. Su crecimiento, desarrollo psicomotor y el resto de su examen físico son normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Derivar a oftalmólogo

B Mantener los controles habituales del lactante

C Solicitar RM de cerebro

D Realizar fondo de ojo

E Indicar parche ocular alternante

Respuesta B. En los primeros meses la fijación y la coordinación binocular son inmaduras, por lo que un estrabismo intermitente es fisiológico hasta los 4 a 6 meses. Si el resto del examen es normal, se mantienen los controles. Debe derivarse si el estrabismo es constante, persiste después de los 6 meses o hay rojo pupilar alterado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 26

Niño de 1 mes con desviación de la mirada de manera intermitente. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Derivar a oftalmología de urgencia

B Solicitar TAC de cerebro

C Mantener controles habituales de niño sano

D Iniciar parche ocular

E Solicitar fondo de ojo urgente

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Mantener controles habituales de niño sano (opción C). Mantener controles habituales de niño sano.

▶ VER CLASE 2.01.1.097 Ojo rojo

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Oftalmología 15.1 · Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo
Oftalmología 15.5 · Escleritis y Epiescleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Ojo rojo superficial (conjuntivitis): hiperemia periférica, secreción, visión normal, sin dolor intenso; manejo en APS.
- Ojo rojo profundo (banderas rojas): dolor intenso, fotofobia, disminución de agudeza visual, inyección ciliar periquerática, pupila alterada, opacidad corneal (queratitis, uveítis anterior, glaucoma).
- Uveítis anterior en niños: asociada a artritis idiopática juvenil oligoarticular con ANA+, frecuentemente asintomática: tamizaje oftalmológico periódico.
- Trauma: erosión corneal (fluoresceína), cuerpo extraño, hifema; quemadura química: irrigación abundante inmediata con SF por 15-30 min.
- Hemorragia subconjuntival aislada: benigna; si recurrente o con petequias, estudiar coagulación. No usar corticoides ni anestésicos tópicos de forma ambulatoria.
- Seguimiento: derivar a oftalmología de urgencia ante banderas rojas, trauma penetrante o químico.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 58 años despierta con una mancha roja viva en el sector nasal del ojo derecho. No refiere traumatismo, dolor, pérdida de visión ni secreción ocular. Al examen: hemorragia plana homogénea que oculta los vasos esclerales en la conjuntiva bulbar nasal, agudeza visual normal en ambos ojos, pupilas normales y córnea transparente. **¿Cuál es la conducta indicada?**

A Indicar ácido tranexámico oral y reposo absoluto

B Tranquilizar al paciente, explicar que se resolverá en 10 a 14 días y no indicar fármacos tópicos

C Instilar colirio de fenilefrina para lograr vasoconstricción inmediata

D Realizar paracentesis conjuntival para evacuar el hematoma

E Derivar de inmediato para fotocoagulación láser

Respuesta B. Hiposfagma o hemorragia subconjuntival espontánea, sin dolor, con visión y pupilas normales: no tiene ningún signo de alarma. La conducta es expectante, con educación y control de la presión arterial si corresponde. Se reabsorbe sola en una a dos semanas, sin fármacos tópicos.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una mujer de 32 años consulta por enrojecimiento sectorial en el ojo derecho de 3 días de evolución, asociado a sensación leve de arenilla, sin dolor intenso ni baja de visión. Al examen: agudeza visual normal bilateral, inyección vascular roja brillante triangular en el sector temporal de la conjuntiva bulbar. Tras instilar una gota de fenilefrina al 2,5%, la hiperemia vascular desaparece casi por completo a los 10 minutos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta médica indicada?**

A Escleritis necrotizante; iniciar pulsos de metilprednisolona endovenosa

B Epiescleritis simple; indicar lubricantes oculares o AINE tópico y tranquilizar a la paciente

C Glaucoma agudo incipiente; indicar pilocarpina al 2% en colirio

D Uveítis anterior aguda; solicitar resonancia magnética cerebral

E Queratitis estromal herpética; iniciar aciclovir endovenoso

Respuesta B. El blanqueamiento vascular completo tras la fenilefrina confirma que el plexo comprometido es el superficial: epiescleritis simple. La conducta es sintomática, con resolución espontánea en una a dos semanas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 52 años con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento con metotrexato consulta por dolor ocular izquierdo muy intenso, de 5 días de evolución, continuo y profundo, que le irradia al hemicráneo y no le deja dormir. Al examen: agudeza visual conservada, hiperemia difusa con marcada coloración violácea en el ojo izquierdo. Se instila fenilefrina al 2,5% y a los 15 minutos el enrojecimiento y el dolor persisten sin cambios. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar colirio de cloranfenicol y control en 1 semana

B Indicar colirio de dexametasona cada 4 horas

C Iniciar AINE oral en dosis altas y derivar de urgencia a oftalmología y reumatología

D Tranquilizar a la paciente e indicar solo lágrimas artificiales

E Indicar colirio de timolol para bajar la presión ocular

Respuesta C. Dolor terebrante nocturno, ojo violáceo profundo, que no blanquea con fenilefrina, en una paciente con artritis reumatoide, es escleritis. Nunca responde a colirios: se trata con AINE oral en dosis altas o corticoides sistémicos, y se deriva de urgencia a oftalmología y reumatología.

▶ VER CLASE 2.01.1.098 Vicios de refracción

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Oftalmología** 15.9 · Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

QUÉ HAY QUE SABER

- Vicios de refracción: hipermetropía (fisiológica en lactantes), miopía (aparece en edad escolar, ve mal de lejos), astigmatismo y anisometropía (riesgo de ambliopía).
- Sospecha: acercarse a la pantalla o al cuaderno, entrecerrar ojos, cefalea tras esfuerzo visual, bajo rendimiento escolar, frotarse los ojos.
- Tamizaje de agudeza visual con tabla de Snellen o figuras desde los 4 años en control de salud; derivar si visión <0,7 (20/30) en ≥5 años o diferencia de 2 líneas entre ojos.
- Tratamiento: corrección óptica (lentes) indicada por oftalmólogo u optómetra; tratar ambliopía antes de los 7-8 años.
- Programa JUNAEB entrega lentes en escolares y vicio de refracción en ≥65 años es GES; en niños mantener controles anuales.
- Seguimiento: derivar a oftalmología para refracción con cicloplejia y control periódico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un escolar de 9 años refiere que no ve bien la pizarra desde hace meses y entrecierra los ojos para mirar de lejos. Lee bien de cerca. La agudeza visual es 20/80 en ambos ojos y mejora a 20/25 con el agujero estenopeico. El resto del examen ocular es normal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Miopía

B Hipermetropía

C Presbicia

D Ambliopía

E Catarata congénita

Respuesta A. Mala visión de lejos con buena visión de cerca, que mejora con el agujero estenopeico (indica un defecto refractivo), es miopía, el vicio de refracción más frecuente en escolares. Se corrige con lentes divergentes indicados por oftalmólogo. La hipermetropía afecta más la visión cercana y da astenopia; la ambliopía no mejora con el estenopeico; la presbicia es del adulto.

▶ VER CLASE 2.01.1.099 Epistaxis

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.11 · Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

QUÉ HAY QUE SABER

- Epistaxis pediátrica: casi siempre anterior, plexo de Kiesselbach; gatillada por grataje, sequedad ambiental, rinitis, cuerpo extraño. Más frecuente 2-10 años.
- Manejo: sentado inclinado hacia adelante, compresión digital de ambas alas nasales por 10-15 min continuos sin soltar; frío local.
- Si persiste: vasoconstrictor tópico (oximetazolina) en algodón y compresión; taponamiento anterior si falla; cauterización química con nitrato de plata en punto sangrante identificado (por ORL).

- Prevención: humidificación, vaselina o suero nasal, cortar uñas, tratar rinitis alérgica.
- Banderas rojas: epistaxis recurrente con otros sangrados o historia familiar (von Willebrand, PTI, hemofilia), unilateral con obstrucción en adolescente varón (nasoangiofibroma juvenil), cuerpo extraño con rinorrea fétida unilateral.
- Seguimiento: control en APS; derivar a ORL si recurrente o refractaria y estudiar coagulación (hemograma, TP, TTPA) si hay sospecha de discrasia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 7 años presenta sangrado nasal por la fosa derecha de 5 minutos, tras rascarse la nariz. Está tranquilo, hemodinámicamente estable y no tiene antecedentes de sangrado ni de uso de fármacos. **¿Cuál es la primera medida?**

A Inclinar la cabeza hacia atrás y aplicar hielo en la frente

B Taponamiento posterior

C Compresión digital continua de las alas nasales por 10 minutos, con la cabeza inclinada hacia adelante

D Cauterización con nitrato de plata como primera medida

E Solicitar pruebas de coagulación urgentes

Respuesta C. La epistaxis en niños es casi siempre anterior, del plexo de Kiesselbach, gatillada por grataje o sequedad. La primera medida es comprimir las alas nasales contra el tabique en forma continua por 10 minutos, con la cabeza inclinada hacia adelante para no deglutir sangre. Si persiste o recurre se cauteriza.

▶ VER CLASE 2.01.1.100 Hipertrofia adenoidea/amigdalina

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.15 · Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipertrofia adenoamigdalina: causa más frecuente de trastorno respiratorio del sueño en niños, peak 3-6 años.
- Clínica: ronquido, pausas respiratorias, sueño inquieto, respiración bucal, voz nasal, facie adenoidea, enuresis, somnolencia o hiperactividad diurna, bajo rendimiento escolar, mal incremento ponderal.
- Clasificar amígdalas (grados 1-4 de Brodsky); adenoides por radiografía de cavum lateral (relación adenoide/nasofaringe) o nasofibroscopía.
- Complicaciones: apnea obstructiva del sueño, hipertensión pulmonar/cor pulmonale, otitis media con efusión recurrente, alteraciones del crecimiento facial.
- Manejo inicial: corticoide intranasal (mometasona) por 6-12 semanas en hipertrofia adenoidea leve-moderada o rinitis asociada; polisomnografía en casos dudosos.
- Seguimiento: derivar a ORL para adenoamigdalectomía si apnea obstructiva del sueño, hipertrofia obstructiva sintomática, otitis recurrente o con efusión persistente.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas constituye una indicación formal para considerar una amigdalectomía en un paciente pediátrico, de acuerdo con los criterios de Paradise? **Elija la alternativa correcta.**

A Haber presentado 2 episodios de amigdalitis bacteriana en el último año

B Presentar 7 episodios documentados de faringoamigdalitis bacteriana en el último año tratados con antibióticos

C Presentar ronquido nasal esporádico únicamente durante los resfriados comunes

D Presencia de placas de caseum amigdalino fétido en criptas sin fiebre ni odinofagia

E Un único episodio de amigdalitis viral asociada a conjuntivitis por adenovirus

Respuesta B. Paradise exige episodios bacterianos documentados y tratados: siete en un año, o cinco por año durante dos años, o tres por año durante tres años. La caseosis amigdalina es benigna y no justifica cirugía.

▶ VER CLASE 2.01.1.101 Hipoacusia

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.5 · Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipoacusia: tamizaje auditivo neonatal universal con emisiones otoacústicas o potenciales evocados auditivos automatizados (GES para prematuros <32 semanas o <1.500 g; hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro).
- Factores de riesgo: prematurez, UCI neonatal >5 días, TORCH (CMV), hiperbilirrubinemia con exanguinotransfusión, meningitis, ototóxicos (aminoglicósidos), historia familiar, malformaciones craneofaciales.
- Hipoacusia de conducción más frecuente: otitis media con efusión, tapón de cerumen. Neurosensorial: congénita (genética, CMV), post meningitis.
- Sospecha: no reacciona a sonidos, retraso del lenguaje, problemas de atención o rendimiento escolar, preocupación de los padres (siempre considerar).
- Estudio: otoscopía; audiometría desde 4-5 años, impedanciometría, potenciales evocados en lactantes.
- Seguimiento: derivar a ORL; intervención (audífonos, implante coclear) idealmente antes de los 6 meses para preservar el lenguaje.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una madre pregunta por el tamizaje auditivo de su recién nacido de término sano, que no tiene factores de riesgo de hipoacusia. **¿Cuál es el examen de tamizaje auditivo neonatal más utilizado en recién nacidos sanos?**

A Audiometría tonal

B Resonancia magnética de oído

C Impedanciometría

D Prueba de diapasones

E Emisiones otoacústicas

Respuesta E. El tamizaje auditivo neonatal busca detectar hipoacusia antes de los 3 meses e intervenir antes de los 6 meses. En recién nacidos sanos se usan las emisiones otoacústicas (rápidas, no invasivas); en prematuros o de alto riesgo se prefieren los potenciales evocados auditivos automatizados, porque detectan neuropatía auditiva. La audiometría tonal requiere cooperación, desde aproximadamente los 4 años.

▶ VER CLASE 2.01.1.102 Otitis media recurrente

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.1 · Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos

QUÉ HAY QUE SABER

- Otitis media aguda recurrente: ≥3 episodios en 6 meses o ≥4 en 12 meses (con 1 en los últimos 6 meses).
- Factores de riesgo: sala cuna, tabaquismo pasivo, uso de chupete o mamadera en decúbito, ausencia de lactancia materna, hipertrofia adenoidea, fisura palatina, síndrome de Down, inmunodeficiencia.
- Diagnóstico de cada episodio con otoscopía; distinguir de otitis media con efusión (líquido sin inflamación aguda, hipoacusia).
- Manejo inicial: tratar episodios agudos con amoxicilina en dosis altas, controlar factores de riesgo, vacunas al día (neumocócica, influenza), lactancia materna.
- No se recomienda profilaxis antibiótica prolongada de rutina; evaluar audición.
- Seguimiento: derivar a ORL para evaluar tubos de ventilación (colleras) ± adenoidectomía y estudio auditivo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 11 meses presenta su tercer episodio de otitis media aguda supurada en los últimos 4 meses, respondiendo satisfactoriamente a la amoxicilina en cada oportunidad. La madre pregunta cuál es la definición médica de su condición y el paso a seguir. **¿Cuál es la respuesta correcta?**

A Corresponde a una otitis media crónica supurada y debe iniciar profilaxis antibiótica diaria con cotrimoxazol.

B Cumple criterios de otitis media recurrente y debe ser derivado al otorrinolaringólogo para evaluación de tubos de ventilación.

C No cumple criterios de recurrencia porque se requieren al menos 5 episodios en 6 meses.

D Se trata de una falla inmunológica primaria y requiere inmunoglobulinas endovenosas mensuales.

E Debe recibir amoxicilina en dosis profiláctica continua durante toda la temporada de invierno.

Respuesta B. OMA recurrente: 3 o más episodios en 6 meses, o 4 o más en 12 meses. Se deriva a ORL para evaluar tubos de ventilación. La quimioprofilaxis prolongada está contraindicada por generar resistencia.

▶ VER CLASE 2.01.1.103 Rinitis alérgica

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.9 · Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales

QUÉ HAY QUE SABER

- Rinitis alérgica: estornudos en salva, rinorrea acuosa, prurito nasal, obstrucción; signos: saludo alérgico, pliegue nasal, ojeras alérgicas, mucosa pálida y edematosa. Asocia asma y dermatitis atópica.
- Clasificación ARIA: intermitente vs persistente (≥4 días/semana y ≥4 semanas); leve vs moderada-grave (altera sueño, colegio o actividades).
- Leve intermitente: antihistamínico de 2ª generación (cetirizina 0,25 mg/kg/día, 5 mg en 2-6 años y 10 mg en >6 años; loratadina 5-10 mg/día; desloratadina).
- Persistente o moderada-grave: corticoide intranasal diario (mometasona o fluticasona), el más eficaz; lavado nasal con suero fisiológico.
- Control ambiental de alérgenos (ácaros, epitelios, pólenes, humo de tabaco); evitar vasoconstrictores nasales >5 días.
- Seguimiento: control en APS; derivar a inmunología/ORL si refractaria, para pruebas cutáneas o inmunoterapia.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un estudiante de 24 años consulta por rinorrea acuosa profusa, prurito ocular y nasal intenso y salvas de estornudos que se presentan durante 5 a 6 días a la semana desde hace 2 meses, coincidiendo con la primavera. Se despierta en la noche con la nariz totalmente obstruida y esto afecta su concentración para estudiar. A la rinoscopía anterior se aprecian cornetes inferiores hipertróficos y pálidos. **De acuerdo con las guías ARIA, ¿cuál es la clasificación de su enfermedad y el tratamiento de primera línea más adecuado?**

A Rinitis alérgica intermitente leve; clorfenamina oral 4 mg cada 8 horas

B Rinitis alérgica persistente moderada-severa; corticoide intranasal en spray diario (ej. fluticasona o mometasona)

C Rinitis vasomotora pura; bromuro de ipratropio nasal según necesidad

D Rinosinusitis crónica poliposa; amoxicilina oral con ácido clavulánico por 21 días

E Rinitis alérgica persistente leve; oximetazolina nasal tópica cada 12 horas por 1 mes

Respuesta B. Los síntomas aparecen 4 o más días a la semana por 4 o más semanas: persistente. Hay alteración del sueño y de la concentración: moderada a severa. La primera línea son los corticoides intranasales, superiores a los antihistamínicos orales para la obstrucción nasal.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un joven de 19 años consulta por obstrucción nasal bilateral constante, estornudos matinales y goteo nasal transparente desde hace 2 meses. No duerme bien por la nariz tapada y en clases está desconcentrado. Hace 3 semanas se aplica spray de oximetazolina 4 veces al día: al comienzo se destapaba de inmediato, pero ahora el efecto dura una hora y se tapa peor. A la rinoscopía, cornetes inferiores engrosados y eritematosos que contactan el tabique. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Aumentar la oximetazolina a cada 4 horas

B Suspender la oximetazolina e iniciar corticoide intranasal, con lavados nasales

C Amoxicilina oral por 7 días

D Solo clorfenamina oral en la noche

E Cirugía de cornetes inmediata

Respuesta B. Es una rinitis alérgica persistente moderada a severa, con una rinitis medicamentosa por oximetazolina sobre 5 días. Se suspende el descongestionante de inmediato, se inicia corticoide intranasal en dosis plenas por 1 a 2 meses y se asocian lavados nasales.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 167

Un niño de 4 años consulta por infecciones recurrentes, habiendo tenido una otitis media aguda, 2 bronquitis y 3 amigdalitis en el último año. Presenta rinorrea con frecuencia, obstrucción nasal, respira por la boca y ronca en la noche. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Rinitis alérgica

B Inmunodeficiencia primaria por déficit de inmunoglobulinas

C Hipertrofia de adenoides

D Fibrosis quística

E Enfermedad de cilio inmóvil

Respuesta A. La rinitis alérgica es la causa más frecuente de obstrucción nasal, rinorrea y respiración bucal en pediatría. La HT de adenoides sí tiene infecciones recurrentes y obstrucción, aunque le sobra la rinorrea. La B, D y E tendrían infecciones bacterianas, sin obstrucción nasal y la D y E tienden a hacer neumonías, mientras que la B sí hace neumonías, pero también las otitis y sinusitis. El número de infecciones recurrentes del paciente no alcanzan a ser realmente infecciones recurrentes.

▶ VER CLASE 2.01.1.104 **Acné** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.2 · Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína

QUÉ HAY QUE SABER

- Acné: enfermedad del folículo pilosebáceo, peak en adolescencia; comedones (no inflamatorio), pápulas y pústulas (inflamatorio leve-moderado), nódulos y quistes (severo, riesgo de cicatriz).
- Acné leve comedoniano: retinoide tópico (adapaleno 0,1% o tretinoína) nocturno; agregar peróxido de benzoílo 2,5-5% si hay lesiones inflamatorias.
- Moderado papulopustular: retinoide tópico + peróxido de benzoílo + antibiótico oral (doxiciclina 100 mg/día o limeciclina) por 3 meses; no usar antibiótico tópico solo.
- En adolescentes con hiperandrogenismo (SOP) considerar anticonceptivos con antiandrógeno.
- Acné severo, nódulo-quístico, cicatrizal o refractario: isotretinoína oral (teratogénica, requiere anticoncepción doble y control de perfil lipídico y transaminasas) por dermatólogo.
- Seguimiento: control a las 8-12 semanas para evaluar respuesta; derivar a dermatología si severo, refractario o con cicatrices.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una adolescente de 13 años consulta por lesiones en la frente y la nariz desde hace 6 meses. Al examen se observan numerosos comedones abiertos y cerrados, sin pápulas inflamatorias, pústulas ni nódulos. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A Isotretinoína oral

B Doxiciclina oral

C Anticonceptivos orales

D Retinoide tópico (ej. adapaleno)

E Corticoide tópico

Respuesta D. Acné comedoniano (no inflamatorio) leve: el tratamiento de elección es un retinoide tópico (adapaleno o tretinoína), que normaliza la queratinización folicular; puede asociarse peróxido de benzoilo. Los antibióticos orales se reservan para acné inflamatorio moderado y la isotretinoína para acné grave, nodular o refractario. Los corticoides tópicos empeoran el acné.

▶ VER CLASE 2.01.1.105 Alteraciones pigmentarias

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.4 · Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)

QUÉ HAY QUE SABER

- Manchas café con leche: ≥6 manchas >5 mm en prepúberes (>15 mm en pospúberes), efélides axilares/inguinales y neurofibromas sugieren neurofibromatosis tipo 1.
- Máculas hipocrómicas en hoja de fresno (luz de Wood), angiofibromas faciales, espasmos infantiles: esclerosis tuberosa.
- Mancha mongólica: mácula gris azulada lumbosacra en RN, benigna, desaparece en la infancia; no confundir con maltrato.
- Vitíligo: máculas acrómicas bien delimitadas, simétricas, asociado a autoinmunidad tiroidea; corticoide o tacrolimus tópico, fototerapia. Pitiriasis alba: máculas hipopigmentadas descamativas en cara de niños atópicos; emolientes y fotoprotección.
- Nevos congénitos grandes (>20 cm) tienen riesgo de melanoma; nevos con cambios (ABCDE) requieren evaluación.
- Seguimiento: derivar a dermatología/neurología si se sospecha síndrome neurocutáneo, nevo congénito gigante o vitíligo extenso.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 3

Un lactante de 12 meses es traído por su madre porque presenta coloración amarillo-anaranjada en las palmas de las manos, las plantas y las mejillas. No tiene otros antecedentes, pesa 9,5 kg, mide 73,5 cm y su examen físico no muestra otras alteraciones; las escleras son blancas. **¿Cuál es la causa de esta alteración?**

A Hipercolesterolemia

B Hipertrigliceridemia

C Hiperbilirrubinemia de predominio directo

D Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto

E Un componente de la dieta

Respuesta E. Coloración amarillo-anaranjada de palmas, plantas y surcos nasogenianos con escleras respetadas, en un lactante sano, es carotenemia por alta ingesta de alimentos ricos en betacarotenos (zanahoria, zapallo). Es benigna y se resuelve al moderar su consumo. La ictericia por hiperbilirrubinemia compromete precozmente las escleras.

▶ VER CLASE 2.01.1.106 Candidiasis urogenital

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.9 · Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Candidiasis del área del pañal: eritema intenso que compromete pliegues, con lesiones satélites (pápulas y pústulas periféricas), favorecida por humedad y antibióticos.
- Tratamiento: clotrimazol o nistatina tópica 2-3 veces al día por 7-14 días, cambio frecuente de pañal y pasta protectora de óxido de zinc.
- Muguet oral asociado: nistatina suspensión oral 4 veces al día; tratar el pezón materno si hay lactancia.
- Vulvovaginitis candidiásica en adolescentes: prurito, flujo blanco grumoso, pH <4,5; clotrimazol óvulo 500 mg dosis única o fluconazol 150 mg VO; en niñas prepúberes es rara (sospechar DM o antibióticos).
- Recurrente o extensa: descartar diabetes, inmunodeficiencia (VIH), uso de corticoides.
- Seguimiento: control si no hay respuesta en 1-2 semanas; candidiasis recurrente o en niña prepúber requiere estudio.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una adolescente de 16 años, sin actividad sexual, terminó hace una semana un tratamiento antibiótico por una faringoamigdalitis. Consulta por prurito vulvar intenso y flujo vaginal blanco, grumoso, sin mal olor. Al examen hay eritema y edema vulvar. El pH vaginal es 4,2. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Metronidazol oral
B Clotrimazol vaginal
C Ceftriaxona intramuscular
D Corticoide tópico de alta potencia
E Doxiciclina oral

Respuesta B. Prurito intenso, flujo blanco grumoso "como leche cortada", sin mal olor y con pH normal (menor a 4,5), tras uso de antibióticos, es candidiasis vulvovaginal. No es una ITS. Se trata con azol tópico (clotrimazol vaginal) o fluconazol oral en dosis única. El metronidazol es para vaginosis bacteriana y tricomoniasis, que elevan el pH.

▶ VER CLASE 2.01.1.107 Dermatitis atópica

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.6 · Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación

QUÉ HAY QUE SABER

- Dermatitis atópica: eccema pruriginoso crónico y recurrente, historia personal o familiar de atopía. Lactante: mejillas y superficies extensoras (respeta el área del pañal); niño: pliegues flexurales.
- Diagnóstico clínico (criterios de Hanifin-Rajka): prurito, morfología y distribución típica, curso crónico, atopía; xerosis, Dennie-Morgan, pitiriasis alba.
- Base del tratamiento: emolientes diarios abundantes, baño corto con agua tibia, jabón syndet, ropa de algodón, evitar irritantes.
- Brotes: corticoide tópico de baja potencia en cara y pliegues (hidrocortisona 1%) y media potencia en cuerpo (mometasona) 1-2 veces al día por 7-14 días; inhibidores de calcineurina (tacrolimus, pimecrolimus) en zonas sensibles; antihistamínico sedante nocturno para prurito.
- Complicaciones: sobreinfección por S. aureus (costras melicéricas: antibiótico), eccema herpético (vesículas umbilicadas, fiebre: aciclovir urgente).
- Seguimiento: control periódico en APS con terapia proactiva; derivar a dermatología si severa o refractaria.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 79

Una niña de 4 años presenta lesiones cutáneas recurrentes de 2 años de evolución, caracterizadas por pápulas pruriginosas que aparecen en los antebrazos y fosas cubitales, así como en las piernas, fosas poplíteas, cara y cuello. Su madre comenta que pasa por periodos de exacerbación de las lesiones y otros en que son mucho menos intensas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Dermatitis alérgica
B Urticaria
C Dermatitis atópica
D Escabiosis
E Dermatitis seborreica

Respuesta C. Lesiones crónico recidivantes, pruriginosas, en pliegues flexurales más mejillas, con periodos de exacerbación y remisión en una niña de 4 años, es una dermatitis atópica clásica en su fase infantil.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 12

Un niño de 20 días de edad presenta lesiones eritematosas, con descamación en la cabeza y la zona interciliar, con descamación amarilla, de aspecto oleoso. Se ve de buen aspecto y ha subido de peso. **¿Cuál es la indicación más adecuada?**

A Administrar fórmula con proteína hidrolizada
B Crema de betametasona tópica
C Crema de clotrimazol tópico
D Vaselina tópica
E Antibióticos tópicos

Respuesta D. Descamación amarilla y oleosa en cuero cabelludo y zona interciliar en un recién nacido de buen aspecto y con buena curva de peso es dermatitis seborreica del lactante, un cuadro benigno. En niños se prefiere no hacer nada o aplicar vaselina, a diferencia del adulto, donde sí se usan antimicóticos tópicos.

▶ VER CLASE 2.01.1.108 Dermatitis del pañal y de contacto

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.7 · Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

QUÉ HAY QUE SABER

- Dermatitis del pañal irritativa: eritema en zonas convexas de contacto que respeta los pliegues; por humedad, orina y deposiciones.
- Tratamiento: cambio frecuente de pañal, aseo con agua tibia sin toallas con alcohol, aire libre, pasta de óxido de zinc en cada muda.
- Compromiso de pliegues con lesiones satélites: sobreinfección por Candida (clotrimazol/nistatina tópica). Descartar dermatitis seborreica (escamas amarillentas en cuero cabelludo y pliegues) y psoriasis.
- Dermatitis de contacto alérgica: lesiones bien delimitadas en zona de contacto (níquel en ombligo, calzado, cosméticos); evitar alérgeno, corticoide tópico de media potencia por 1-2 semanas.

- Dermatitis de contacto irritativa: por jabones, saliva (perioral), detergentes; emolientes y barrera.
- Seguimiento: control si no hay respuesta en 1-2 semanas; derivar a dermatología si persistente o atípica (test de parche).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 118

Lactante con eritema en la zona del pañal que no responde a óxido de zinc. Al examen se observa eritema intenso que compromete los pliegues inguinales, con pápulas y pústulas satélite en la periferia. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Clotrimazol tópico
B Mupirocina tópica
C Hidrocortisona tópica al 1%
D Óxido de zinc en mayor concentración
E Fluconazol oral

Respuesta A. La dermatitis irritativa del pañal respeta los pliegues; cuando los compromete y aparecen lesiones satélite, se ha sobreinfectado por Candida albicans. El tratamiento es un antifúngico tópico (clotrimazol o nistatina) junto con cambios frecuentes de pañal y barrera. El fluconazol oral no es necesario en la candidiasis cutánea localizada.

▶ VER CLASE 2.01.1.109 Ectoparasitosis

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.16 · Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Escabiosis (Sarcoptes scabiei): prurito intenso nocturno, pápulas y surcos en espacios interdigitales, muñecas, axilas, cintura y genitales; en lactantes compromiso de palmas, plantas y cara; contagio familiar.
- Escabiosis: permetrina 5% crema de cuello a pies (incluir cuero cabelludo en lactantes) por 8-12 h, repetir a los 7 días; tratar a todos los contactos simultáneamente y lavar ropa a >60 °C. Alternativa ivermectina oral en >15 kg.
- Pediculosis capitis: prurito, liendres adheridas al pelo; permetrina 1% loción, repetir a los 7-10 días, retiro mecánico de liendres con peineta fina; revisar contactos.
- Prurito puede persistir 2-4 semanas tras tratamiento (no implica falla).
- Sobreinfección bacteriana (impétigo) requiere antibiótico; prurigo por picaduras de insectos (pulgas, chinches) es diferencial.
- Seguimiento: control a las 2-4 semanas; fracaso suele deberse a no tratar contactos o mala aplicación.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 144

Niño de 8 años con lesiones eritematosas papulosas en manos, pies, axilas y zona interdigital, muy pruriginosas, que empeoran de noche. También afectados su hermano y su madre. **¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?**

A Escabiosis: permetrina 5% tópica + tratar a todos los contactos
B Dermatitis atópica: emolientes y corticoides tópicos
C Tinea pedis: clotrimazol tópico
D Erupción por contacto: evitar alérgeno
E Impétigo: mupirocina tópica

Respuesta A. Prurito nocturno con lesiones papulosas en espacios interdigitales, axilas, manos y pies, que afecta a varios convivientes: escabiosis por Sarcoptes scabiei. El tratamiento es permetrina al 5% en todo el cuerpo, tratando simultáneamente a todos los contactos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 131

Una prescolar de 4 años presenta prurito en la cabeza. Al examen físico se ven abundantes liendres, a menos de 3 cm del cuero cabelludo, sin visualizar piojos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Ivermectina oral
B Permetrina tópica al 1%
C Permetrina tópica al 5%
D Lindano tópico
E No tratar, mientras no se visualicen piojos

Respuesta B. Liendres a menos de 3 cm del cuero cabelludo indican infestación activa por Pediculus humanus capitis, aunque no se vean piojos adultos. El tratamiento de la pediculosis es permetrina tópica al 1%, distinta a la concentración usada en la escabiosis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 131

Una preescolar de 4 años presenta prurito en la cabeza. Al examen físico se ven abundantes liendres a menos de 3 cm del cuero cabelludo, sin visualizar piojos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Ivermectina oral
B Permetrina tópica al 1%
C Permetrina tópica al 5%
D Lindano tópico
E No tratar mientras no se visualicen piojos

Respuesta B. Liendres a menos de 1 a 3 cm del cuero cabelludo son viables y diagnostican pediculosis activa aunque no se vean piojos. El tratamiento de primera línea es permetrina al 1% tópica, repetida a los 7 a 10 días, más remoción mecánica con peineta fina y revisión de contactos.

▶ VER CLASE 2.01.1.110 Infecciones micóticas de piel y fanéreos

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.16 · Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Tiña capitis (Microsporum canis la más frecuente): placa alopécica descamativa con pelos cortados; kerion (placa inflamatoria supurativa). Requiere tratamiento oral: griseofulvina 20-25 mg/kg/día por 6-8 semanas o terbinafina.
- Tiña corporis: placa anular con borde activo descamativo y centro claro; tratamiento tópico con clotrimazol, miconazol o terbinafina por 2-4 semanas.
- Tiña pedis e intertrigo: maceración interdigital; antifúngico tópico. Onicomicosis en niños es infrecuente; requiere confirmación con examen micológico y tratamiento oral prolongado.
- Pitiriasis versicolor (Malassezia): máculas hipo o hipercrómicas con descamación fina en tronco de adolescentes; ketoconazol champú o azoles tópicos.
- Confirmar con examen micológico directo y cultivo en casos dudosos; no usar corticoide tópico (tiña incógnita).
- Seguimiento: control al final del tratamiento; tiña capitis hasta cultivo negativo; investigar mascotas (gatos, perros) como fuente.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 6 años, que tiene un perro, presenta desde hace 3 semanas una placa en el cuero cabelludo con pelos cortados a pocos milímetros de la piel y descamación. En los últimos días la lesión se volvió inflamatoria, dolorosa, con pústulas y supuración, y tiene adenopatías occipitales. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Clotrimazol tópico
B Corticoide tópico
C Cefadroxilo oral
D Drenaje quirúrgico
E Griseofulvina oral por 6 a 8 semanas

Respuesta E. Placa alopécica con pelos cortados y descamación es tiña capitis (Microsporum canis, frecuente por contacto con mascotas). La forma inflamatoria con pústulas y supuración es el querion de Celso, una reacción inmune y no una infección bacteriana. La tiña capitis siempre requiere antifúngico oral (griseofulvina o terbinafina por semanas), porque el tópico no penetra el folículo. El drenaje está contraindicado.

▶ VER CLASE 2.01.1.111 Malformaciones vasculares cutáneas

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Dermatología** 16.17 · Tumores Benignos de Piel, Hemangiomas Infantiles y Malformaciones Vasculares

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemangioma infantil: tumor vascular benigno más frecuente; ausente o pequeño al nacer, crece rápido en los primeros meses (proliferación) e involuciona lentamente en años.
- Malformaciones vasculares: presentes al nacer, crecen proporcionalmente y no involucionan: mancha en vino de Oporto (capilar), venosas, linfáticas, arteriovenosas.
- Mancha salmón (nevus simplex) en nuca o glabela: benigna, frecuente, se aclara.
- Banderas rojas: hemangioma periocular (ambliopía), en vía aérea («en barba», estridor), labio, nariz, ulcerados, múltiples (>5: ecografía hepática), segmentario facial (síndrome PHACE); vino de Oporto en territorio V1 (Sturge-Weber: convulsiones, glaucoma).
- Tratamiento de hemangioma de riesgo: propranolol oral 2-3 mg/kg/día por especialista, idealmente antes de los 3-5 meses.
- Seguimiento: derivar precozmente a dermatología hemangiomas de riesgo y malformaciones vasculares; los no complicados se observan con fotos seriadas.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 83

Un recién nacido de 10 días presenta un hemangioma en el párpado derecho, de 3 cm de diámetro, que cubre parcialmente el eje visual. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?**

A Administrar propranolol
B Administrar betametasona
C Realizar embolización
D Derivar a cirujano plástico
E Observar evolución

Respuesta A. La mayoría de los hemangiomas infantiles involucionan solos y se observan, pero los periorbitarios que ocluyen el eje visual tienen riesgo de ambliopía y deben tratarse precozmente, antes de la fase proliferativa máxima. El tratamiento de primera línea es propranolol oral, con evaluación oftalmológica. Los corticoides quedaron como segunda línea y la cirugía deja cicatriz.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 126

Un lactante de 6 meses presenta ocho hemangiomas infantiles localizados en el tronco, principalmente en la espalda. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?

A Solicitar ecografía abdominal
B Iniciar propranolol oral
C Iniciar corticoides intralesionales
D Solicitar una resonancia magnética nuclear de cerebro
E Solicitar estudio de neurofibromatosis

Respuesta A. Hemangiomas Infantiles: La presencia de múltiples hemangiomas infantiles obliga a descartar hemangiomas viscerales con una ecografía abdominal. El propranolol oral es el tratamiento de elección para los hemangiomas complicados o deformantes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 19

Niño con 6 hemangiomas en tronco y extremidades. ¿Qué examen solicitar inicialmente?

A RNM de cerebro
B TAC de tórax
C Gammagrafía ósea
D Ecografía abdominal
E Angiografía por resonancia

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Ecografía abdominal). Ecografía abdominal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 87

Un recién nacido de 5 días de vida tiene un hemangioma en el párpado izquierdo, de 1 cm de diámetro, que cubre parcialmente el iris. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Observar evolución
B Indicar propanolol oral
C Indicar corticoides orales
D Biopsiar
E Derivar a cirujano plástico infantil

Respuesta B. La primera medida ante los hemangiomas infantiles es dar propanolol. Si no involucionan, en casos como este está indicada la cirugía (porque deforma la cara, produce ambliopía, etc).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 41

Una recién nacida de 27 días de vida presenta 6 hemangiomas superficiales, en el tronco y extremidades. El resto de su examen físico es normal y no tiene antecedentes de importancia. ¿Cuál examen es más adecuado para proseguir el estudio de esta paciente?

A Ecografía abdominal
B Ecografía cerebral
C Resonancia magnética nuclear espinal
D Ecografía de partes blandas
E Resonancia magnética nuclear de cerebro

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Resonancia magnética nuclear espinal).

▶ VER CLASE | 2.01.1.112 | **Alteraciones de la termorregulación** | DX ESPECÍFICO | TX COMPLETO | SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.15 · Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

QUÉ HAY QUE SABER

- Temperatura normal del RN: 36,5-37,5 °C axilar; el RN pierde calor por evaporación, radiación, conducción y convección.
- Hipotermia neonatal (<36,5 °C): mayor riesgo en prematuros y bajo peso; produce hipoglicemia, acidosis, apnea, dificultad respiratoria y aumento de mortalidad.
- Prevención: secado inmediato, contacto piel a piel, sala a 26-28 °C, gorro, cuna radiante o incubadora; bolsa plástica en prematuros <32 semanas.
- Hipertermia en RN: frecuentemente ambiental (exceso de abrigo) o deshidratación; descartar sepsis siempre ante fiebre en RN.
- Manejo: recalentar gradualmente (incubadora), monitorizar glicemia y respiración; desabrigar y evaluar hidratación en hipertermia ambiental.
- Seguimiento: control de temperatura seriado; RN con fiebre real requiere estudio de sepsis y hospitalización.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 100

Un recién nacido de término, de 37 semanas de gestación y peso de 2.900 g, presenta temperatura corporal de 35,5 °C sin otras alteraciones. Se realiza secado de la piel y se indica contacto piel con piel con su madre; sin embargo, persiste con temperatura en dicho rango. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Poner en incubadora a 38 °C

B Poner en incubadora precalentada y ajustar progresivamente la temperatura

C Poner en cuna con calor radiante, sin ropa ni cobertor

D Administrar suero glucosado al 10% por vía endovenosa

E Cubrir al recién nacido con mantas

Respuesta B. La hipotermia neonatal moderada (32 a 35,9 °C) que no responde a medidas generales (secado, piel con piel, abrigo) se trata con recalentamiento controlado en incubadora precalentada, ajustando la temperatura en forma progresiva y monitorizando glicemia. Un recalentamiento brusco a 38 °C puede causar apneas e hipotensión.

▶ VER CLASE 2.01.1.113 Apneas

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.18 · Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM

QUÉ HAY QUE SABER

- Apnea: pausa respiratoria ≥20 s, o menor si se acompaña de bradicardia (<100 lpm), cianosis o desaturación.
- Apnea del prematuro: inmadurez del centro respiratorio, frecuente en <34 semanas, inicia en los primeros días y resuelve hacia las 36-40 semanas corregidas.
- Diferencial obligado: sepsis, hipoglicemia, hipocalcemia, hipotermia, anemia, convulsiones, hemorragia intraventricular, reflujo, VRS o coqueluche en lactantes.
- Manejo inicial: estimulación táctil, permeabilizar vía aérea, O2 o ventilación a presión positiva si no cede; estudio de causas secundarias.
- Tratamiento de apnea del prematuro: cafeína (citrato de cafeína carga 20 mg/kg, mantención 5-10 mg/kg/día); CPAP si persiste.
- Seguimiento: hospitalizar en neonatología; derivar al especialista y alta tras 5-7 días sin apneas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un recién nacido prematuro de 29 semanas, al tercer día de vida, presenta episodios repetidos de pausas respiratorias de más de 20 segundos, con bradicardia y desaturación, que ceden con estímulo táctil. Se han descartado hipoglicemia, sepsis, anemia, alteraciones electrolíticas y hemorragia intraventricular. **¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección?**

A Cafeína (citrato de cafeína)

B Fenobarbital

C Salbutamol

D Surfactante

E Naloxona

Respuesta A. Las apneas de más de 20 segundos, o menores con bradicardia o desaturación, en un prematuro menor de 34 semanas, tras descartar causas secundarias, corresponden a apnea del prematuro por inmadurez del centro respiratorio. El tratamiento de elección es el citrato de cafeína, un estimulante respiratorio, más medidas de soporte o CPAP si persisten. El fenobarbital deprime la respiración.

▶ VER CLASE 2.01.1.114 Asfixia neonatal

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.15 · Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

QUÉ HAY QUE SABER

- Asfixia neonatal: falla del intercambio gaseoso perinatal con hipoxemia, hipercapnia y acidosis metabólica. Criterios: pH de cordón <7,0, Apgar ≤3 a los 5 min, encefalopatía y falla multiorgánica.
- Factores de riesgo: desprendimiento placentario, prolapso de cordón, distocias, sufrimiento fetal (bradicardia), infección intraamniótica, RCIU.
- Manejo inicial: reanimación neonatal según algoritmo (pasos iniciales, ventilación a presión positiva efectiva es lo más importante); evitar hiperoxia.
- Post reanimación: monitorización en UCI, normoglicemia, normotermia (evitar hipertermia), balance hídrico, tratar convulsiones con fenobarbital.
- Hipotermia terapéutica antes de las 6 h de vida si encefalopatía moderada-grave en ≥35-36 semanas.
- Seguimiento: derivar a neonatología; seguimiento del neurodesarrollo a largo plazo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de 39 semanas, por cesárea de urgencia por desprendimiento de placenta. Requirió ventilación a presión positiva y masaje cardíaco. Apgar 2 al minuto y 4 a los 5 minutos. Gases de cordón: pH 6,88 y exceso de base −18. A las 2 horas de vida está hipotónico, letárgico, con reflejos primitivos débiles. **¿Cuál es la intervención que más reduce la mortalidad y las secuelas neurológicas en este paciente?**

A Bicarbonato de sodio endovenoso para corregir la acidosis

B Fenobarbital profiláctico

C Hiperventilación para bajar el CO2

D Hipotermia terapéutica iniciada antes de las 6 horas de vida

E Hidratación con aporte hídrico alto para mejorar la perfusión renal

Respuesta D. Acidosis grave en cordón, Apgar bajo persistente, reanimación avanzada y encefalopatía moderada a severa definen asfixia neonatal con encefalopatía hipóxico-isquémica. La hipotermia terapéutica, iniciada antes de las 6 horas, es la única intervención que reduce muerte y discapacidad. El bicarbonato y el fenobarbital profiláctico no están indicados.

▶ VER CLASE 2.01.1.115 Convulsiones neonatales

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.20 · Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato

QUÉ HAY QUE SABER

- Convulsiones neonatales: generalmente sutiles (movimientos de pedaleo, chupeteo, desviación ocular, apneas), clónicas focales o tónicas; diferenciar de temblores (ceden al sujetar la extremidad y son estímulo-sensibles).
- Causa más frecuente: encefalopatía hipóxico-isquémica (primeras 24-48 h); otras: hemorragia intracraneana, infarto, infecciones (meningitis, TORCH), hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, errores innatos del metabolismo, abstinencia.
- Estudio inicial: glicemia capilar inmediata, calcio, magnesio, electrolitos, gases, hemograma, PCR, hemocultivo, punción lumbar, ecografía cerebral; EEG (idealmente continuo).
- Corregir trastornos metabólicos: hipoglicemia con suero glucosado 10% 2 ml/kg EV; hipocalcemia con gluconato de calcio 10% 1-2 ml/kg EV lento.
- Anticonvulsivante de primera línea: fenobarbital 20 mg/kg EV (repetir 10 mg/kg hasta 40 mg/kg); luego levetiracetam o fenitoína.
- Seguimiento: derivar a neonatología y neurología infantil.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un recién nacido de término, hijo de madre con diabetes gestacional, presenta a las 6 horas de vida movimientos de pedaleo de extremidades y desviación ocular sostenida, de 1 minuto de duración. Está en buenas condiciones generales, sin fiebre. **¿Cuál es la primera medida diagnóstica?**

A Electroencefalograma

B Punción lumbar

C Glicemia capilar

D Ecografía cerebral

E Resonancia magnética cerebral

Respuesta C. Ante una convulsión neonatal, lo primero es medir la glicemia capilar, porque la hipoglicemia es una causa frecuente, rápidamente tratable y que deja secuelas si no se corrige; el hijo de madre diabética tiene alto riesgo. Luego se miden calcio, magnesio y electrolitos y se buscan otras causas (encefalopatía hipóxico-isquémica, infección, hemorragia). El EEG y las imágenes vienen después.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 26

RN de término convulsión a las 12 hrs de 2 minutos de duración. A la evaluación todo normal hgtes: diagnóstico más probable

A Epilepsia

B Hipoglicemia

C Hipocalcemia

D Hemorragia intracerebral

E Accidente cerebrovascular

Respuesta B. Diagnóstico: Hipoglicemia (opción B).

▶ VER CLASE 2.01.1.116 Enterocolitis necrotizante (ECN)

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.3 · Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

QUÉ HAY QUE SABER

- Enterocolitis necrotizante: necrosis isquémica-inflamatoria del intestino, principalmente en prematuros alimentados con fórmula, a las 2-3 semanas de vida.
- Clínica: distensión abdominal, intolerancia alimentaria con residuo gástrico bilioso, deposiciones con sangre, letargia, apneas, inestabilidad térmica, shock.
- Radiografía de abdomen: neumatosis intestinal (signo patognomónico), gas en vena porta; neumoperitoneo indica perforación. Clasificación de Bell.
- Manejo inicial: régimen cero, sonda orogástrica abierta, NPT, hemocultivos y antibióticos EV de amplio espectro (ampicilina + gentamicina + metronidazol), soporte hemodinámico.

- Perforación o deterioro clínico: cirugía (laparotomía o drenaje peritoneal). Prevención: leche materna, alimentación enteral progresiva.
- Seguimiento: derivar a UCI neonatal con cirugía infantil; secuelas estenosis intestinal e intestino corto.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 146

Recién nacido de 10 días de vida, con antecedente de haber nacido prematuro a las 27 semanas, alimentado con fórmula láctea para prematuros por sonda nasogástrica, presenta un cuadro de 2 días de evolución de distensión abdominal y aumento de la retención láctea, objetivada por la sonda. Se solicita radiografía simple de abdomen, que muestra dilatación de asas intestinales, con zonas de engrosamiento de la pared intestinal y visualización de burbujas en algunos segmentos. **Además de suspender la fórmula láctea y asegurar una adecuada hidratación por vía endovenosa, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar resolución quirúrgica inmediata

B Iniciar alimentación con fórmula hidrolizada de proteínas por sonda nasoenteral

C Administrar antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa

D Realizar endoscopía digestiva alta

E Alimentar con suero glucosado por vía oral

Respuesta C. Prematuro con distensión abdominal y retención láctea, más burbujas de aire en la pared intestinal en la radiografía: enterocolitis necrotizante. Ya con régimen cero e hidratación endovenosa en marcha, el paso siguiente es agregar antibióticos de amplio espectro. La cirugía se reserva a la perforación, la necrosis o la falla del tratamiento médico; no se alimenta al niño, ni por sonda ni por boca.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 120

RNPT que a los 6 días inicia con vómitos importantes y deposiciones con sangre, abdomen timpánico con RHA disminuidos o ausentes (no recuerdo cual), que se vería en la radiografía:

A Asas dilatadas con niveles hidroaéreos (esta era la más sugerente de enterocolitis necrotizante)

B Aire libre intraperitoneal

C Pared intestinal engrosada

D Signo de doble burbuja

E Derrame pleural

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Asas dilatadas con niveles hidroaéreos (esta era la más sugerente de enterocolitis necrotizante)).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 30

Recién nacido de 35 semanas, de 5 días de vida, con antecedente de depresión neonatal recuperada, inicia cuadro caracterizado por vómitos y distensión abdominal asociado a deposiciones con sangre. Al examen físico se palpa abdomen distendido, con tono aumentado. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

A Ecografía abdominal

B Tomografía axial computada de abdomen con contraste

C Radiografía de abdomen

D Laparotomía exploradora

E Colonoscopía

Respuesta C. Diagnóstico: Radiografía de abdomen (opción C). La ECN se estudia con Rx simple.

▶ VER CLASE 2.01.1.117 Estridor congénito

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.17 · Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Estridor congénito: laringomalacia es la causa más frecuente (60-70%): estridor inspiratorio desde las primeras semanas, aumenta con llanto, alimentación y decúbito supino, mejora en prono.
- Curso: peak 6-8 meses y resolución espontánea entre 12-24 meses en la mayoría.
- Otras causas: parálisis de cuerdas vocales (llanto débil), estenosis subglótica (post intubación), hemangioma subglótico (estridor progresivo, hemangiomas cutáneos), anillos vasculares (estridor bifásico, disfagia).
- Banderas rojas: apneas, cianosis, dificultad para alimentarse, mal incremento ponderal, retracción importante, estridor bifásico o progresivo.
- Manejo inicial de laringomalacia leve: observación, tranquilizar, tratar reflujo si coexiste.
- Seguimiento: derivar a ORL infantil para nasofibrolaringoscopía si banderas rojas o duda diagnóstica; supraglotoplastía en casos graves.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 162

Un recién nacido de término presenta estridor desde el nacimiento, sin otros síntomas. Al examen físico está en buenas condiciones, sin cianosis ni uso de musculatura accesoria. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Anillo vascular
B Traqueomalacia
C Laringomalacia
D Hendidura laríngea
E Fístula traqueoesofágica

Respuesta C. La laringomalacia es la causa más frecuente de estridor congénito: estridor inspiratorio que aparece en las primeras semanas, aumenta con el llanto, la alimentación o el decúbito supino, en un lactante con buen estado general. Suele resolverse espontáneamente entre los 12 y 24 meses. La traqueomalacia y el anillo vascular dan estridor espiratorio o bifásico.

▶ VER CLASE 2.01.1.118 Hijo madre diabética

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.20 · Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato

QUÉ HAY QUE SABER

- Hijo de madre diabética: hiperglicemia materna produce hiperinsulinismo fetal: macrosomía (GEG), visceromegalia y riesgo de trauma obstétrico (distocia de hombros, parálisis braquial, fractura de clavícula).
- Complicaciones metabólicas: hipoglicemia en las primeras horas (el riesgo principal), hipocalcemia, hipomagnesemia, policitemia, hiperbilirrubinemia.
- Otras: síndrome de distrés respiratorio (retraso de maduración pulmonar), miocardiopatía hipertrófica septal, malformaciones (DM pregestacional mal controlada): cardiopatías, síndrome de regresión caudal, colon izquierdo pequeño.
- Manejo: alimentación precoz (primera hora), glicemias seriadas desde la 1ª-2ª hora por 24-48 h; hipoglicemia <45-47 mg/dL: alimentar o bolo de suero glucosado 10% 2 ml/kg y luego infusión.
- Controlar hematocrito, calcio, bilirrubina; ecocardiograma si soplo o dificultad respiratoria.
- Seguimiento: derivar a neonatología si complicaciones; riesgo de obesidad y DM2 a futuro, controles de crecimiento en APS.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de 39 semanas, hijo de madre con diabetes gestacional en tratamiento con insulina. Nace por cesárea, peso 4.350 g. A las 2 horas de vida presenta temblores finos de extremidades, succión débil y tono algo disminuido. El hemoglucotest marca 32 mg/dL, confirmado por glicemia venosa en 30 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Ofrecer pecho materno y controlar la glicemia en 2 horas más
B Bolo de suero glucosado al 10 % 2 mL/kg en 5 minutos, seguido de infusión continua
C Bolo rápido de suero glucosado al 50 % 5 mL/kg
D Observación estricta, sin tratamiento, por ser un hallazgo esperable en un hijo de madre diabética
E Hidrocortisona endovenosa como primera línea

Respuesta B. Hijo de madre diabética, macrosómico, con hipoglicemia sintomática (temblores, succión débil) y glicemia venosa de 30 mg/dL: es una urgencia. La alimentación sola no corrige rápido ni previene el daño neurológico. El manejo es bolo de suero glucosado al 10 % 2 mL/kg endovenoso en 5 minutos, seguido de infusión continua con carga de 6 a 8 mg/kg/min.

▶ VER CLASE 2.01.1.119 Hipocalcemia

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.20 · Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipocalcemia neonatal: calcio total <8 mg/dL (o <7 en prematuros) o calcio iónico <4 mg/dL (1 mmol/L).
- Precoz (primeras 72 h): prematurez, hijo de madre diabética, asfixia, RCIU. Tardía (5-10 días): aporte alto de fosfato (leche de vaca), hipoparatiroidismo (síndrome de DiGeorge: cardiopatía conotruncal, timo ausente), déficit de vitamina D materna, hipomagnesemia.
- Clínica: frecuentemente asintomática; irritabilidad, temblores, hiperreflexia, convulsiones, apneas; QT prolongado.
- Tratamiento sintomático: gluconato de calcio 10% 1-2 ml/kg EV lento en 10 min con monitor cardíaco (riesgo de bradicardia y necrosis por extravasación); luego mantención.
- Corregir hipomagnesemia concomitante (si no, la hipocalcemia no corrige).
- Seguimiento: derivar a neonatología/endocrinología si hipocalcemia tardía, refractaria o sospecha de hipoparatiroidismo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de 37 semanas, hijo de madre diabética pregestacional, de 30 horas de vida. Presenta temblores de extremidades e irritabilidad. Glicemia 62 mg/dL. Calcio total 6,6 mg/dL. El electrocardiograma muestra un intervalo QT prolongado. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Bolo de suero glucosado al 10% 2 mL/kg

B Fenobarbital endovenoso por sospecha de convulsión

C Gluconato de calcio en bolo rápido sin monitorización

D Gluconato de calcio al 10% 1 a 2 mL/kg endovenoso lento, con monitor cardíaco

E Solo observación, porque es esperable en el hijo de madre diabética

Respuesta D. Calcio bajo 8 mg/dL en un recién nacido de término es hipocalcemia; el hijo de madre diabética es grupo de riesgo. Con síntomas o QT prolongado se trata con gluconato de calcio al 10% endovenoso lento con monitor, porque pasarlo rápido causa bradicardia y arritmias. La glicemia es normal.

▶ VER CLASE 2.01.1.120 Hipoglicemia

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.20 · Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipoglicemia neonatal: glicemia <45-47 mg/dL en RN (umbral operativo); en niños mayores <50-60 mg/dL.
- RN de riesgo: hijo de madre diabética, GEG, PEG, prematuros, asfixia, sepsis, hipotermia; tamizar con glicemias seriadas desde la primera hora.
- Clínica: temblores, irritabilidad, hipotonía, succión débil, apneas, cianosis, convulsiones; puede ser asintomática.
- Manejo: asintomático con glicemia límite: alimentar y repetir; sintomático o <25-30 mg/dL: bolo de suero glucosado 10% 2 ml/kg EV y luego infusión con carga de glucosa 4-8 mg/kg/min.
- Persistente o con requerimiento de carga >10-12 mg/kg/min: hiperinsulinismo, hipopituitarismo, insuficiencia suprarrenal o error innato; tomar muestra crítica (insulina, cortisol, GH, cetonas) durante la hipoglicemia.
- Seguimiento: derivar a neonatología/endocrinología si persistente o recurrente; riesgo de daño neurológico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 150

Recién nacido de término, con antecedente de madre con preeclampsia, pesa 2.600 gramos al nacer. **¿Cuál es la complicación más frecuente durante las primeras horas de vida?**

A Hipoglicemia

B Sepsis

C Hiperbilirrubinemia

D Anemia

E Distrés respiratorio

Respuesta A. La preeclampsia materna suele producir un recién nacido pequeño para la edad gestacional, con reservas de glucógeno casi nulas. La complicación más frecuente en las primeras horas es la hipoglicemia, no la anemia ni el distrés respiratorio.

▶ VER CLASE 2.01.1.121 Ictericia neonatal y del primer trimestre

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.17 · Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia

QUÉ HAY QUE SABER

- Ictericia neonatal: fisiológica aparece después de las 24 h, peak día 3-5, bilirrubina indirecta, RN en buen estado, resuelve antes del día 10-14. Progresión céfalo-caudal (zonas de Kramer).
- Patológica: aparición <24 h (hemólisis por incompatibilidad Rh o ABO: grupo y Rh de madre y RN, Coombs directo), ascenso rápido, bilirrubina directa >1-2 mg/dL o >20%, duración >14 días.
- Conducta según nomograma de Bhutani (bilirrubina total y horas de vida) y factores de riesgo: fototerapia en zona de riesgo; exanguinotransfusión si falla o signos de encefalopatía aguda (kernicterus).
- Ictericia por lactancia ineficaz: corregir técnica, no suspender lactancia. Ictericia por leche materna: tardía, benigna, RN que sube de peso.
- Colestasia (acolia, coluria, bilirrubina directa elevada, ictericia >14 días): urgencia por atresia de vías biliares (cirugía de Kasai antes de los 60 días); ecografía y derivación inmediata.
- Seguimiento: control a las 24-48 h del alta en RN con ictericia; derivar a neonatología si fototerapia o a gastroenterología si colestasia.

PREGUNTAS · 11

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 129

Recién nacido de 18 horas de vida con ictericia hasta los muslos. La bilirrubina resulta en 15,3 miligramos por decilitro, con fracción indirecta de 15. La madre es de grupo O, Rh positiva; el niño es de grupo B, Rh negativo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico

B Ictericia hemolítica por incompatibilidad Rh

C Ictericia fisiológica

D Hepatitis neonatal

E Ictericia por lactancia materna

Respuesta A. Solo una madre Rh negativa puede hemolizar a un hijo Rh positivo; aquí es al revés, así que la incompatibilidad Rh queda descartada. En cambio, una madre de grupo O puede hemolizar a un hijo de grupo A o B: es incompatibilidad de grupo clásico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 60

Un recién nacido de 18 horas de vida desarrolla ictericia hasta los muslos. Los niveles plasmáticos de bilirrubina resultan 15,3 mg/dl, con fracción indirecta de 15 mg/dl. La madre es O-IV Rh positiva y el niño es B-I Rh negativo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico

B Ictericia hemolítica por incompatibilidad Rh

C Ictericia fisiológica

D Hepatitis neonatal

E Síndrome de Gilbert

Respuesta A. Ictericia a las 18 horas: patológica. La madre O e hijo B calzan con incompatibilidad ABO. La incompatibilidad Rh exige madre Rh negativo e hijo Rh positivo; aquí es al revés (madre Rh positiva, hijo Rh negativo), así que esa opción queda descartada por definición.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 39

Un lactante de 5 días de vida, alimentado con lactancia materna exclusiva, presenta ictericia en la cara y el tronco, que inició hace 2 días. La bilirrubina plasmática resulta 10 mg/dl, bilirrubina directa de 0,3 mg/dl, hematocrito de 56%. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Hepatitis neonatal

B Atresia biliar primaria

C Ictericia fisiológica

D Ictericia hemolítica

E Ictericia por leche materna

Respuesta C. Ictericia que apareció al tercer día, con bilirrubina indirecta moderada y directa normal: patrón fisiológico. El hematocrito alto no cambia el diagnóstico, es parte esperable del recién nacido y no un signo de alarma por sí solo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 154

Un niño de 6 semanas de vida presenta ictericia desde hace 2 semanas. Al examen físico se aprecia ictérico y presenta deposiciones claras en el pañal, sin otras alteraciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Estenosis hipertrófica del píloro

B Atresia biliar primaria

C Hepatitis viral

D Síndrome de Crigler Najjar

E Hipotiroidismo congénito

Respuesta B. Ictericia tardía, de más de dos semanas, con deposiciones claras (acolia): patrón colestásico clásico de atresia biliar. Las otras opciones no explican las deposiciones acólicas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 117

Un lactante de un mes, sin antecedentes perinatales, es traído por presentar ictericia hasta los muslos, resto normal. Su desarrollo psicomotor, crecimiento y alimentación han sido normales. Al preguntar dirigidamente, la madre refiere que también ha presentado orinas oscuras. **¿Cuál es el examen de elección frente a este paciente?**

A Ecografía abdominal

B Hormona estimulante de la tiroides

C Resonancia magnética abdominal

D Test de Coombs

E Bilirrubinemia diferenciada

Respuesta E. Ictericia tardía con coluria: sospecha de colestasia. Pero antes de pedir imágenes, el primer paso siempre es medir la bilirrubina diferenciada, para confirmar que el componente directo está elevado. Recién con eso se justifica avanzar a la ecografía.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de 16 horas de vida, de término, vigoroso, nacido por parto vaginal sin incidentes. La matrona nota ictericia marcada en cara, tronco y abdomen (zona 3 de Kramer). La madre es primigesta, grupo O Rh positivo; el recién nacido es grupo A Rh positivo. La bilirrubina total es de 9,2 mg/dL con bilirrubina directa de 0,4 mg/dL. El hematocrito es de 44%. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Dar de alta con control ambulatorio en 7 días

B Hospitalizar, iniciar fototerapia y solicitar Coombs directo

C Suspender la lactancia materna por 48 horas

D Solicitar ecografía abdominal para descartar atresia biliar

E Indicar fenobarbital oral para inducir la conjugación hepática

Respuesta B. Ictericia a las 16 horas de vida: patológica y hemolítica hasta demostrar lo contrario. La madre grupo O y el hijo grupo A orientan a incompatibilidad ABO. A esa hora de vida, 9,2 mg/dL cae en zona de alto riesgo de Bhutani: fototerapia inmediata más Coombs directo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 176

Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un recién nacido de término presenta ictericia a los 7 días de vida. Se solicita bilirrubina total: 14,2 mg/dl y bilirrubina directa: 4,0 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Solicitar hemograma, grupo-Rh y prueba de Coombs directo al recién nacido

B Solicitar hemograma, grupo-Rh y prueba de Coombs directo a la madre

C Solicitar pruebas hepáticas

D Solicitar sedimento de orina y urocultivo

E Fototerapia

Respuesta C. Una bilirrubina directa de 4 mg/dl (más de 1 mg/dl y cerca de 30% de la total) a los 7 días de vida es una hiperbilirrubinemia directa, que no es fisiológica y obliga a descartar colestasis, como atresia de vías biliares o hepatitis neonatal. Lo adecuado es pedir pruebas hepáticas y estudio de la vía biliar. El estudio hemolítico apunta a hiperbilirrubinemia indirecta y la fototerapia no está indicada con estos niveles.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 145

Un niño de 27 días de vida presenta ictericia, que inició hace una semana. Se alimenta con lactancia materna exclusiva y no ha tenido otros síntomas. Se solicitan exámenes que muestran una bilirrubina total de 18,8 mg/dl y una bilirrubina directa de 18,0 mg/d. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Ictericia por leche materna

B Ictericia fisiológica

C Atresia primaria de las vías biliares

D Hipotiroidismo congénito

E Hepatitis neonatal

Respuesta C. Tiene una ictericia tardía y directa, por lo que la atresia biliar primaria es la principal sospecha.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 61

Un niño de 5 semanas de vida presenta ictericia, que inició hace una semana. Se alimenta con lactancia materna exclusiva y no ha tenido otros síntomas. Se solicitan exámenes que muestran una bilirrubina total de 4,3 mg/dl y una bilirrubina directa de 3,6 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Ictericia por lactancia materna

B Síndrome de Gilbert

C Atresia primaria de las vías biliares

D Hipotiroidismo congénito

E Hepatitis neonatal

Respuesta C. Tiene una ictericia tardía, de predominio directo, por lo que se sospecha una atresia biliar primaria. A, B y D son de predominio indirecto. La hepatitis neonatal es menos importante como diagnóstico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 29

Un recién nacido de 2 días de vida, presenta aumento de volumen parietal izquierdo, que deforma la cabeza, limitado a la zona parietal, que no sobrepasa la línea media. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la alteración descrita?

A Fistulización a la piel

B Osteomielitis

C Disección de cuero cabelludo

D Hiperbilirrubinemia

E Abscedación

Respuesta D. La hiperbilirrubinemia es la complicación más frecuente del cefalohematoma (descrito en el caso). Las demás pueden ocurrir, pero son infrecuentes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 154

Un neonato de 21 días de vida, con incremento ponderal deficiente, presenta ictericia que se extiende hasta las piernas. El parto fue por vía vaginal y el embarazo transcurrió sin complicaciones. Su bilirrubina total es de 11,2 mg/dL, con una bilirrubina directa de 7,0 mg/dL. El neonato se encuentra alimentándose con lactancia materna exclusiva y no presenta otros síntomas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Atresia de vías biliares
B Hipotiroidismo congénito
C Ictericia fisiológica
D Ictericia por leche materna
E Síndrome de Gilbert

Respuesta A. Ictericia Neonatal Directa: En un caso de ictericia neonatal tardía de predominio directo, el diagnóstico más probable es atresia de vías biliares. Se debe realizar una ecografía abdominal para confirmar el diagnóstico. Se trata con la cirugía de Kasai.

▶ VER CLASE 2.01.1.122 Poliglobulia

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Pediatría 18.20 · Hipoglicemia Neonatal, Hipocalcemia & Trastornos Metabólicos del Neonato

QUÉ HAY QUE SABER

- Poliglobulia neonatal: hematocrito venoso >65% (o capilar >70%); hiperviscosidad sanguínea con riesgo de hipoperfusión.
- Causas: transfusión placentaria (clampeo tardío), hipoxia crónica intrauterina (RCIU, PEG, preeclampsia, tabaquismo), hijo de madre diabética, transfusión feto-fetal, trisomía 21, hipotiroidismo.
- Clínica: plétora, letargia, temblores, dificultad respiratoria, cianosis, hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, ECN, trombocitopenia.
- Confirmar con hematocrito venoso (el capilar sobreestima); controlar glicemia y bilirrubina.
- Manejo: asintomático con Hto 65-70%: hidratación adecuada y control; sintomático o Hto >70-75%: exanguinotransfusión parcial con suero fisiológico.
- Seguimiento: derivar a neonatología si sintomático o requiere recambio.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un recién nacido de término, pequeño para la edad gestacional, a las 12 horas de vida se ve pletórico, con letargia, temblores y succión débil. Exámenes: hematocrito venoso 71% y glicemia 38 mg/dL. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado de la poliglobulia?**

A Flebotomía simple sin reposición
B Exsanguinotransfusión parcial con suero fisiológico
C Hidratación oral exclusiva y control
D Transfusión de plaquetas
E Fototerapia

Respuesta B. Poliglobulia neonatal es un hematocrito venoso mayor a 65%; en pequeños para la edad gestacional se debe a hipoxia crónica intrauterina. Causa hiperviscosidad, con letargia, hipoglicemia, dificultad respiratoria o enterocolitis. Si es sintomática (o el hematocrito es mayor a 70 a 75%), se realiza exsanguinotransfusión parcial con suero fisiológico para bajar el hematocrito a 55%, además de corregir la glicemia.

▶ VER CLASE 2.01.1.123 Prematurez

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Pediatría 18.16 · Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal
Pediatría 18.18 · Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM

QUÉ HAY QUE SABER

- Prematuro: RN <37 semanas; extremo <28, muy prematuro 28-32, moderado/tardío 32-36+6. Principal causa de morbimortalidad neonatal.
- Complicaciones: SDR por déficit de surfactante, apneas, hemorragia intraventricular, ductus persistente, ECN, sepsis, displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, hipotermia, hipoglicemia, ictericia.
- Prevención: corticoides antenatales (betametasona) entre 24-34 semanas, sulfato de magnesio <32 semanas (neuroprotección), traslado in utero a centro con UCI neonatal.
- Manejo inicial: termorregulación (bolsa plástica <32 sem), CPAP precoz y surfactante, alimentación con leche materna, aporte de glucosa.
- Programas GES: retinopatía del prematuro, displasia broncopulmonar e hipoacusia en <1.500 g o <32 semanas; seguimiento en policlínico de prematuros con edad corregida hasta los 2 años (vacunas por edad cronológica).
- Seguimiento: derivar a neonatología y policlínico de seguimiento; nirsevimab/palivizumab en temporada de VRS, suplemento de hierro desde los 2 meses.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de 30 semanas, con peso de nacimiento de 1.250 gramos, hospitalizado en neonatología. Recibió surfactante y oxígeno durante las primeras 2 semanas. Hoy tiene 4 semanas de vida, está estable, sin apoyo ventilatorio y en ganancia de peso. **Según las garantías GES para el prematuro, ¿qué evaluación corresponde realizar ahora?**

A Electroencefalograma de rutina

B Cariograma

C Fondo de ojo por oftalmólogo para pesquisa de retinopatía del prematuro

D Densitometría ósea

E Resonancia magnética de cerebro de rutina

Respuesta C. El prematuro menor de 32 semanas o menor de 1.500 gramos tiene garantía GES de pesquisa de retinopatía del prematuro con fondo de ojo por oftalmólogo, habitualmente desde las 4 semanas de vida; el oxígeno recibido es un factor de riesgo adicional. También tiene garantía de pesquisa de hipoacusia.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de 28 semanas, de 3 días de vida, en CPAP nasal. Presenta episodios repetidos de pausas respiratorias de más de 20 segundos, acompañados de bradicardia y desaturación, que ceden con estimulación táctil. Está normotérmico, con glicemia y hemograma normales y PCR negativa. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Citrato de cafeína endovenoso u oral

B Ampicilina más gentamicina por 10 días

C Fenobarbital endovenoso

D Intubación y ventilación mecánica inmediatas

E Suspender la alimentación enteral por 1 semana

Respuesta A. Pausas de más de 20 segundos con bradicardia o desaturación en un prematuro, sin otra causa, son apneas del prematuro por inmadurez del centro respiratorio. El tratamiento de elección es la cafeína. Descartada la sepsis, los antibióticos no corresponden, y la intubación queda para la falla del tratamiento.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 122

Qué leche le das a un RN prematuro que ya tiene 12 meses:

A Fórmula 3 de continuación (se da formula prematuros hasta el año de edad corregida)

B leche de vaca

C Fórmula para prematuros

D Leche semidescremada

E Ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Fórmula 3 de continuación (se da formula prematuros hasta el año de edad corregida)).

▶ VER CLASE 2.01.1.124 Sepsis neonatal

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.19 · Sepsis Neonatal: Precoz (< 72 h) vs Tardía (> 72 h), Esquema Ampicilina + Aminoglucósido y Cefotaxima

QUÉ HAY QUE SABER

- Sepsis neonatal precoz (<72 h): transmisión vertical; estreptococo grupo B y E. coli (Listeria menos). Factores de riesgo: RPM >18 h, corioamnionitis, fiebre materna, SGB+ sin profilaxis, prematurez.
- Tardía (>72 h): nosocomial (S. coagulasa negativo, S. aureus, gram negativos, Candida) o comunitaria.
- Clínica inespecífica: inestabilidad térmica, letargia, rechazo alimentario, apneas, dificultad respiratoria, ictericia, mala perfusión; alta sospecha.
- Estudio: hemograma (leucopenia, índice inmaduros/totales >0,2), PCR seriada, hemocultivos, punción lumbar si estable, urocultivo en tardía.
- Tratamiento empírico precoz: ampicilina + gentamicina (o cefotaxima si sospecha meningitis); no usar ceftriaxona en RN con hiperbilirrubinemia o calcio EV.
- Prevención: tamizaje de SGB a las 35-37 semanas y profilaxis intraparto con penicilina; seguimiento hospitalizado en neonatología.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 99

Recién nacido de 10 días de vida, sin antecedentes perinatales, inicia desde hace 5 horas cuadro de fiebre hasta 39 ºC asociada a rechazo alimentario e hiporreactividad, sin otros síntomas. Su examen físico resulta normal. La bioquímica de orina muestra leucocitos ++. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar sedimento de orina y decidir conducta según resultados

B Hospitalizar para estudio y manejo

C Indicar antipiréticos orales y control en dos días

D Indicar antibióticos vía oral y control en dos días

E Solicitar ecografía renal y vesical

Respuesta B. Recién nacido menor de 28 días con fiebre y rechazo alimentario: se hospitaliza siempre para estudio séptico completo y manejo, independiente de que existan hallazgos aislados como los leucocitos en orina.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de 28 horas de vida, hijo de madre sin controles prenatales regulares, cuyo parto ocurrió tras 22 horas de rotura de membranas con fiebre materna intraparto de 38,4 grados. El niño no quiere mamar, está pálido y frío al tacto. Temperatura axilar de 35,8 grados, frecuencia cardíaca 174 por minuto, llene capilar de 4 segundos. El hemograma muestra 4.100 leucocitos por mm3 con una relación de inmaduros sobre totales de 0,32. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Alta con control ambulatorio en 48 horas

B Hospitalizar, tomar cultivos e iniciar ampicilina más gentamicina de inmediato

C Solo antipiréticos y observación por 24 horas

D Iniciar vancomicina más amikacina de entrada

E Suero glucosado y control de glicemia exclusivamente

Respuesta B. Menos de 72 horas de vida, con factores de riesgo mayores (RPM prolongada y sospecha de corioamnionitis) y signos de sepsis (hipotermia, mala succión, taquicardia, llene capilar lento) más leucopenia con desviación a la izquierda: sepsis neonatal precoz. Se hospitaliza, se toman cultivos y se inicia ampicilina más gentamicina sin retrasar el tratamiento.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un residente propone tratar la sospecha de sepsis neonatal precoz solo con cefotaxima, en lugar de la combinación de ampicilina más un aminoglucósido, argumentando que la cefotaxima ya cubre bien a los gramnegativos. **¿Por qué la ampicilina es obligatoria en el esquema, y no puede reemplazarse por cefotaxima sola?**

A Porque las cefalosporinas no cubren a Escherichia coli

B Porque Listeria monocytogenes tiene resistencia intrínseca a todas las cefalosporinas

C Porque la ampicilina es el único fármaco activo contra Pseudomonas

D Porque las cefalosporinas están contraindicadas en el recién nacido

E Por razones exclusivamente de costo

Respuesta B. La Listeria monocytogenes es intrínsecamente resistente a todas las cefalosporinas, incluida la cefotaxima. Por eso la ampicilina es un componente insustituible del esquema empírico de la sepsis neonatal precoz, sin importar cuánto cubra la cefotaxima a los demás gérmenes.

▶ VER CLASE 2.01.1.125 Síndrome aspirativo meconial

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.18 · Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome aspirativo meconial: RN de término o postérmino con líquido amniótico meconial y sufrimiento fetal; aspiración produce obstrucción, inflamación química e inactivación de surfactante.
- Clínica: dificultad respiratoria precoz, tórax en tonel, piel y uñas teñidas de meconio. Rx: infiltrados gruesos parcheados, hiperinsuflación, atrapamiento aéreo, neumotórax.
- Complicación grave: hipertensión pulmonar persistente del RN (diferencia de saturación pre-post ductal).
- Reanimación: no se recomienda aspiración intraparto ni intubación de rutina para aspirar tráquea en RN deprimido; iniciar ventilación a presión positiva en el primer minuto (aspirar solo si hay obstrucción).
- Manejo: O2, CPAP o ventilación mecánica, surfactante, óxido nítrico inhalado si hipertensión pulmonar, antibióticos si no se descarta infección.
- Seguimiento: derivar a UCI neonatal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de 41 semanas y 5 días, por parto vaginal con registro fetal alterado y líquido amniótico con meconio espeso. A los 20 minutos de vida presenta taquipnea de 80 rpm, retracción intercostal, tórax en tonel y saturación de 86%. La radiografía muestra infiltrados gruesos y parcheados bilaterales, con zonas de atelectasia alternadas con zonas de hiperinsuflación. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Enfermedad de membrana hialina

B Taquipnea transitoria del recién nacido

C Hernia diafragmática congénita

D Neumonía connatal por estreptococo grupo B

E Síndrome de aspiración meconial

Respuesta E. Postérmino con sufrimiento fetal y meconio espeso, dificultad respiratoria precoz y tórax hiperinsuflado, con infiltrados gruesos que alternan atelectasias y enfisema, es aspiración meconial: el meconio actúa como válvula. La membrana hialina es del prematuro, con vidrio esmerilado y volumen pulmonar disminuido.

▶ VER CLASE 2.01.1.126 Síndrome distress respiratorio

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.18 · Dificultad Respiratoria Neonatal: EMH (Déficit de Surfactante) vs TTNR (Pulmón Húmedo) vs SAM

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome de distrés respiratorio (enfermedad de membrana hialina): déficit de surfactante en prematuros (inversamente proporcional a la edad gestacional); factores de riesgo hijo de madre diabética, cesárea sin trabajo de parto, asfixia, sexo masculino.
- Clínica: dificultad respiratoria progresiva desde el nacimiento (quejido, retracción, aleteo, taquipnea, cianosis), empeora las primeras 48-72 h.

- Rx: infiltrado reticulogranular fino difuso (vidrio esmerilado), broncograma aéreo, volumen pulmonar disminuido.
- Diferencial: taquipnea transitoria del RN (término por cesárea, cisuritis, mejora en 24-72 h), neumonía/sepsis, SAM, cardiopatía.
- Manejo: CPAP precoz, surfactante exógeno (técnicas mínimamente invasivas o intubación), O2 con meta saturación 90-95%, termorregulación; antibióticos hasta descartar sepsis.
- Prevención: corticoides antenatales 24-34 semanas. Seguimiento: hospitalizar en UCI neonatal; riesgo de displasia broncopulmonar.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 177

Un recién nacido de 36 semanas de edad gestacional, nacido por cesárea, presenta dificultad respiratoria luego de nacer, con taquipnea, retracción subcostal y crepitantes basales. La radiografía de tórax muestra ambos campos pulmonares con hiperinsuflación, reforzamiento hiliar, aplanamiento de los diafragmas y silueta cardiaca normal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Neumomediastino
B Neumonía connatal
C Taquipnea transitoria
D Enfermedad de membrana hialina
E Cardiopatía congénita

Respuesta C. Nacido por cesárea, sin antecedentes de asfixia ni prematurez extrema, con radiografía hiperinsuflada y silueta cardiaca normal: taquipnea transitoria. La membrana hialina daría el patrón opuesto, con pulmón hipoinsuflado.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un recién nacido de 30 semanas de gestación presenta dificultad respiratoria grave desde el nacimiento, con quejido espiratorio constante, cianosis y retracción costal severa. La radiografía de tórax revela campos pulmonares poco expandidos, con opacificación reticulonodular bilateral difusa y broncograma aéreo visible. **¿Cuál es la etiología y el tratamiento de elección?**

A Retardo en la reabsorción de líquido alveolar; oxígeno por naricera
B Déficit de surfactante pulmonar; CPAP nasal e instilación de surfactante exógeno
C Aspiración masiva de meconio; lavado traqueal con solución fisiológica
D Neumotórax a tensión bilateral; toracocentesis inmediata
E Atresia esofágica congénita; sonda con tracción

Respuesta B. Prematuro de 30 semanas, distrés severo desde el nacimiento, con radiografía hipoinsuflada en vidrio esmerilado y broncograma: enfermedad de membrana hialina por déficit de surfactante. Tratamiento: CPAP nasal más surfactante exógeno endotraqueal.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de 31 semanas de gestación, nace por parto prematuro espontáneo. La madre no recibió corticoides prenatales. Inmediatamente presenta quejido audible a distancia, aleteo nasal y retracción xifoidea acentuada, con una saturación de oxígeno de 82% al aire ambiental. La radiografía muestra pulmones con volumen disminuido, patrón difuso en vidrio esmerilado y broncograma aéreo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Oxígeno por naricera y control en 24 horas
B CPAP nasal precoz más surfactante exógeno endotraqueal
C Ventilación mecánica invasiva sin surfactante
D Antibióticos endovenosos de amplio espectro
E Observación, porque es un cuadro autolimitado

Respuesta B. Prematuro de 31 semanas, sin corticoides, con dificultad respiratoria desde el nacimiento y radiografía en vidrio esmerilado con broncograma: enfermedad de membrana hialina. Tratamiento estándar: CPAP nasal precoz más surfactante exógeno endotraqueal.

▶ VER CLASE 2.01.1.127 TORCH

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.2 · Síndrome Mononucleósico y Complejo TORCH

QUÉ HAY QUE SABER

- TORCH: toxoplasmosis, otros (sífilis, VIH, varicela, parvovirus, Zika), rubéola, CMV (la infección congénita más frecuente) y herpes simple.
- Hallazgos comunes: RCIU, microcefalia, hepatoesplenomegalia, ictericia, petequias/trombocitopenia, coriorretinitis, hipoacusia.
- Claves: toxoplasma calcificaciones difusas, hidrocefalia, coriorretinitis; CMV calcificaciones periventriculares e hipoacusia neurosensorial; rubéola cataratas, cardiopatía (ductus), sordera; sífilis rinitis serosanguinolenta, pénfigo palmoplantar, osteocondritis.
- Diagnóstico: CMV con PCR en orina/saliva en las primeras 3 semanas; toxoplasma IgM/IgA y PCR; sífilis VDRL/RPR del RN vs materno (título ≥4 veces) y LCR; herpes PCR.
- Tratamiento inicial: sífilis congénita penicilina G sódica EV 10 días; herpes aciclovir EV; CMV sintomático valganciclovir (especialista); toxoplasma pirimetamina + sulfadiazina + ácido folínico.
- Seguimiento: derivar a infectología/neonatología; evaluación auditiva, oftalmológica y del neurodesarrollo. Prevención: tamizaje de sífilis, VIH y Chagas en embarazo.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 18

RN con microcefalia, calcificaciones periventriculares y coriorretinitis. Madre con serología IgG positiva para CMV y IgM positiva. **¿Cuál es el agente causante de la infección congénita?**

A Citomegalovirus (CMV)
B Toxoplasma gondii
C Virus herpes simplex tipo 2
D Treponema pallidum
E Virus de rubéola

Respuesta A. Calcificaciones periventriculares + microcefalia: CMV congénito, la infección congénita viral más frecuente. El Toxoplasma da calcificaciones difusas con hidrocefalia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 96

Un recién nacido de 38 semanas, presenta hipotonía, dificultad a la succión y circunferencia craneana 26 cm. Al examen tiene ausencia del rojo pupilar bilateral y ambas pupilas se observan de aspecto blanquecino. Además, se ausculta un soplo sistólico eyectivo III/VI, paraesternal. **¿Cuál es el agente más probable?**

A Virus rubéola
B Parvovirus B12
C Citomegalovirus
D Toxoplasma gondii
E Virus herpes simplex

Respuesta A. Microcefalia + catarata congénita (leucocoria, sin rojo pupilar) + cardiopatía congénita: rubéola congénita (tríada de Gregg).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 145

Un recién nacido presenta hepatoesplenomegalia e ictericia. Tiene además calcificaciones cerebrales y microcefalia. Evoluciona con coriorretinitis y aumento progresivo del perímetro craneano. **El diagnóstico más probable es:**

A Infección por VIH
B Infección por Streptococcus agalactiae
C Rubeóla congénita
D Toxoplasmosis congénita
E Sífilis congénita

Respuesta D. TORCH con calcificaciones cerebrales, coriorretinitis y aumento progresivo del perímetro craneano (hidrocefalia): toxoplasmosis congénita, tétrada de Sabin. La rubéola da catarata, hipoacusia y cardiopatía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 77

Un recién nacido de término, pequeño para la edad gestacional, presenta un cuadro de ictericia y alteración de la termorregulación. Al examen físico tiene un síndrome purpúrico y se palpa hepatoesplenomegalia. Se solicitan exámenes, en los que destaca trombocitopenia. ¿Cuál es el agente más probable?

A Virus rubéola
B Citomegalovirus
C Virus herpes simplex
D Treponema pallidum
E Estreptococo betahemolítico grupo B

Respuesta B. Es un TORCH clásico (pequeño para la edad gestacional), cuya causa más frecuente es el CMV. La sepsis (por SGB) puede tener un cuadro similar, pero le sobra lo pequeño para la edad gestacional.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 46

Recién nacido de término, con peso bajo para edad gestacional, tiene perímetro cefálico menor a percentil 3 para la edad gestacional y evoluciona después de nacer con ictericia progresiva, más hepatomegalia. ¿Cuál es el agente causal más probable?

A Citomegalovirus
B Virus papiloma humano
C VIH
D Virus Zika
E Chlamydia trachomatis

Respuesta A. Es un TORCH clásico por CMV (microcefalia, calcificaciones cerebrales, ictericia y hepatoesplenomeglalia). En Chile no hay Zika. El TORCH por toxoplasma es casi igual al del CMV, pero es más infrecuente y, además, puede cursar con hidrocefalia.

▶ VER CLASE `2.01.1.128` **RN PEG-GEG** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.16 · Evaluación de la Edad Gestacional (Capurro/Ballard) & Clasificación Ponderal Neonatal

QUÉ HAY QUE SABER

- Clasificación por peso y edad gestacional: PEG <p10 (pequeño), AEG p10-p90, GEG >p90 según curvas nacionales (Alarcón-Pittaluga).
- PEG: causas maternas (HTA, preeclampsia, tabaco), placentarias o fetales (genéticas, TORCH). Riesgos: hipoglicemia, hipotermia, policitemia, hipocalcemia, asfixia.
- GEG: hijo de madre diabética u obesa; riesgos de trauma obstétrico, hipoglicemia, policitemia, hiperbilirrubinemia.
- Manejo inicial de ambos: alimentación precoz, glicemias seriadas en las primeras 24-48 h, control de temperatura y hematocrito.
- PEG debe recuperar talla (catch-up) a los 2 años; si no recupera, derivar a endocrinología (candidato a hormona de crecimiento). Mayor riesgo de síndrome metabólico en adultez.
- Seguimiento: controles de crecimiento y desarrollo en APS; derivar si complicaciones o falta de recuperación de talla.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 8

Recién nacido pequeño para la edad gestacional, con un peso de 2.500 gramos. **¿Qué conducta tomas respecto de la alimentación?**

A Iniciar fórmula láctea hipercalórica

B Instalar sonda nasogástrica para alimentación

C Ayuno de 6 horas y luego fórmula de prematuro

D Pecho materno precoz y control de glicemia a las 2 horas

E Suero glucosado al 10% endovenoso

Respuesta D. El recién nacido pequeño para la edad gestacional tiene alto riesgo de hipoglicemia precoz: la conducta es alimentar precozmente al pecho y controlar la glicemia a las 2 horas de vida.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 8

Recién nacido pequeño para la edad gestacional, 2.500 g. **¿Qué conducta tomar en relación a la alimentación?**

A Iniciar fórmula láctea hipercalórica

B Instalar sonda nasogástrica para alimentación

C Ayuno de 6 horas y luego fórmula de prematuro

D Pecho materno precoz y control de glicemia a las 2 horas

E Suero glucosado al 10 % endovenoso

Respuesta D. El recién nacido pequeño para la edad gestacional tiene reservas mínimas de glucógeno, así que es de riesgo aunque nazca sin ningún síntoma. La conducta de entrada no es el suero: es pecho materno precoz, con control de glicemia a las 2 horas, tal como viste en el primer escalón del manejo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de sexo masculino, parto vaginal a las 35 semanas, peso de nacimiento de 2.850 gramos. En las curvas de crecimiento intrauterino, ese peso corresponde al percentil 92 para las 35 semanas. **¿Cuál es la clasificación correcta de este paciente?**

A Recién nacido de término, pequeño para la edad gestacional

B Recién nacido de término, adecuado para la edad gestacional

C Recién nacido pretérmino, grande para la edad gestacional

D Recién nacido pretérmino, adecuado para la edad gestacional

E Recién nacido postérmino, grande para la edad gestacional

Respuesta C. A las 35 semanas es pretérmino, y un peso en el percentil 92 está sobre el percentil 90, lo que define grande para la edad gestacional: pretérmino GEG.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 73

Una niña nace por parto vaginal de término. Su peso al nacer es 2.500 gramos, que es menor al percentil para la edad gestacional. Su Apgar fue 9-9-10, observándose enflaquecida, pero vigorosa. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la alimentación?

A Administrar suero glucosado al 5% endovenoso y controlar glicemia en 2 horas

B Administrar suero glucosado al 5% oral

C Alimentar con fórmula láctea hasta que la madre produzca leche

D Dar fórmula láctea después de cada toma de leche materna

E Alimentar inmediatamente al pecho materno y solicitar glicemia a las 2 horas de vida

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Administrar suero glucosado al 5% oral (opción B).

▶ VER CLASE 2.01.1.129 **Alteraciones menstruales** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.3 · Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Ciclos irregulares son normales los primeros 1-2 años post menarquia (anovulación); ciclo normal adolescente 21-45 días, sangrado ≤7 días.
- Amenorrea primaria: sin menarquia a los 15 años con caracteres sexuales secundarios, o a los 13 sin ellos (o 3 años post telarquia). Causas: Turner, agenesia mülleriana, himen imperforado (dolor cíclico, hematocolpos), retraso constitucional.

- Amenorrea secundaria: descartar siempre embarazo (β-hCG); luego anorexia/ejercicio intenso, SOP, hipotiroidismo, hiperprolactinemia.
- Sangrado uterino anormal: lo más frecuente anovulatorio; descartar coagulopatía (von Willebrand en menorragia desde la menarquia), embarazo e ITS. Hemograma, β-hCG, TSH, estudio de coagulación.
- Manejo inicial: dismenorrea primaria con AINE (ibuprofeno, ácido mefenámico) iniciado antes del dolor; sangrado anovulatorio con anemia: hierro, progestágeno o anticonceptivo combinado; hemodinámicamente inestable: hospitalizar.
- Seguimiento: derivar a ginecología infantojuvenil si amenorrea primaria, sangrado con anemia o sospecha de causa orgánica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una adolescente de 13 años tuvo su menarquia hace 10 meses. Desde entonces sus ciclos son irregulares, cada 25 a 50 días, con duración de 4 a 7 días y sangrado moderado. No tiene anemia, hirsutismo, acné importante ni galactorrea, y su IMC es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar anticonceptivos orales para regular el ciclo

B Solicitar ecografía pélvica y perfil hormonal completo

C Solicitar estudio de coagulación

D Tranquilizar y controlar con calendario menstrual

E Iniciar progestágeno cíclico

Respuesta D. En los primeros 2 a 3 años tras la menarquia es frecuente la irregularidad menstrual por inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis-ovario (ciclos anovulatorios). Se consideran normales ciclos de 21 a 45 días aproximadamente. Sin anemia, sangrado abundante ni signos de hiperandrogenismo, la conducta es educar, llevar calendario y controlar.

▶ VER CLASE 2.01.1.130 Leucorrea y vulvovaginitis

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.9 · Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Vulvovaginitis inespecífica: la más frecuente en niñas prepúberes; mala higiene (aseo de atrás hacia adelante), ropa ajustada, irritantes, oxiuros. Prurito, eritema vulvar, flujo escaso.
- Específicas en prepúberes: S. pyogenes (vulvitis eritematosa intensa), Shigella (flujo sanguinolento), cuerpo extraño (flujo fétido sanguinolento persistente).
- Tratamiento inespecífica: medidas de higiene, baños de asiento, ropa de algodón, evitar jabones perfumados; tratar oxiuros si hay prurito anal nocturno.
- Adolescente: vaginosis bacteriana (flujo gris, olor a pescado, test de aminas +, pH >4,5: metronidazol 500 mg c/12 h por 7 días), candidiasis, tricomoniasis (flujo amarillo-verdoso espumoso; tratar a la pareja).
- ITS (gonorrea, Chlamydia, Trichomonas, sífilis) en niña prepúber: sospechar abuso sexual y activar protocolo de protección y denuncia.
- Seguimiento: control en 2-4 semanas; derivar a ginecología infantojuvenil si recurrente, sangrado o sospecha de cuerpo extraño.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una niña de 6 años presenta flujo vaginal amarillento escaso, prurito y eritema vulvar de 2 semanas. Usa ropa interior sintética, se baña en tina con espuma y se limpia de atrás hacia adelante. No hay sangrado, cuerpo extraño visible, lesiones sugerentes de abuso ni oxiuros. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Medidas de higiene: limpieza de adelante hacia atrás, ropa de algodón, evitar baños de espuma

B Metronidazol oral

C Vaginoscopía bajo anestesia

D Óvulos de clotrimazol

E Ceftriaxona intramuscular

Respuesta A. La vulvovaginitis inespecífica es la causa más frecuente de flujo en niñas prepuberales, por mucosa hipoestrogénica delgada, cercanía al ano y mala higiene. El manejo inicial son medidas higiénicas. La candidiasis es rara antes de la pubertad salvo uso de pañal o antibióticos. Si persiste o hay sangrado, se cultiva el flujo y se descarta cuerpo extraño o abuso.

▶ VER CLASE 2.01.1.131 Sinequias vulvares

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.27 · Uroginecología Pediátrica: Fimosis, Sinequias Vulvares y Enuresis

QUÉ HAY QUE SABER

- Sinequia de labios menores: fusión adquirida de labios menores en niñas de 3 meses a 6 años por hipoestrogenismo fisiológico e irritación.
- Clínica: generalmente asintomática; puede causar goteo post miccional, ITU, vulvovaginitis o retención urinaria si es completa.
- Examen: línea media translúcida que une los labios menores; diferenciar de imperforación himeneal y genitales ambiguos.
- Asintomática: no requiere tratamiento, resuelve espontáneamente con estrógenos de la pubertad; higiene adecuada.
- Sintomática: estrógeno tópico (estriol o estrógenos conjugados) 1-2 veces al día por 2-4 semanas con tracción suave; luego vaselina para evitar recurrencia. No separar a la fuerza sin anestesia.
- Seguimiento: control al terminar el tratamiento; recurrencia frecuente; derivar a ginecología infantil si falla el tratamiento o retención urinaria.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 154

Una niña de 4 años presenta sinequia vulvar que une gran parte de los labios menores, por lo que impide ver el introito y el himen. No tiene desarrollo puberal, ni antecedentes de infecciones urinarias ni genitales. El resto de su examen físico es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar lavados con ácido acético
B Aplicar corticoides tópicos
C Remover las sinequias de manera quirúrgica
D Realizar separación manual bajo anestesia local
E Indicar lubricación diaria con vaselina

Respuesta E. Las sinequias de labios menores son frecuentes en niñas prepuberales por el hipoestrogenismo fisiológico y suelen resolverse espontáneamente con la pubertad. Si son asintomáticas se manejan con aseo y lubricación (vaselina); si dan síntomas se usa estrógeno tópico. La separación manual o quirúrgica se reserva para casos complicados (retención urinaria) por la alta recurrencia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 109

Una niña de 4 años presenta sinequia vulvar parcial, de los labios menores. No tie- ne desarrollo puberal, ni antecedentes de infecciones urinarias, ni genitales. El resto de su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

A Realizar lavados con ácido acéticos
B Aplicar corticoides tópicos
C Remover las sinequias de manera quirúrgica
D Indicar antibióticos
E Realizar aseo y masajes en la zona

Respuesta E. Es una pregunta difícil, ya que en distintas partes se manejan de manera diferen- te. Sin embargo, la mayor evidencia dice que el aseo es lo más importante para que se resuleva. Los masajes pueden ayudar a que se desprenda antes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 179

Una niña de 2 años de edad es traída por su madre a control de niño sano. Al examen físico se objetivan genitales con labios menores completamente adheridos entre sí en la línea media, lo que impide la visualización de la vagina y el meato urinario. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Resección quirúrgica de las adherencias
B Realizar avulsión digital, bajo anestesia local con lidocaína
C Indicar aseo genital diario con vaselina líquida
D Aplicar pantenol tópico en la zona perineal por 15 días
E Aplicar betametasona tópica en la zona afectada por 10 días

Respuesta E. Manejo de las Sinequias Vulvares: El tratamiento de las sinequias vulvares (adherencias labiales) es controvertido. La mayoría de los casos son asintomáticas y solo requieren observación. Sin embargo, el tratamiento tópico con estrógenos o corticosteroides se considera para las sinequias extensas (este caso), las que desvían el flujo urinario, causan dolor, o se asocian con flujo o infecciones recurrentes (vaginales o urinarias). Si en estos casos no hay mejoría después del tratamiento tópico,...

▶ VER CLASE 2.01.1.132 Dismorfias

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.26 · Genética y Dismorfias: Síndrome de Down (Trisomía 21) y Síndromes Genéticos Frecuentes

QUÉ HAY QUE SABER

- Dismorfias: características físicas inusuales; menores (pliegue palmar único, epicanto, clinodactilia) son frecuentes aisladas; ≥3 menores aumentan riesgo de malformación mayor o síndrome.
- Evaluación: antecedentes de embarazo (teratógenos: alcohol, fármacos, infecciones), consanguinidad, historia familiar, examen dirigido (cara, manos, pies, genitales, columna) y crecimiento.
- Síndromes frecuentes: trisomía 21, alcohol fetal (filtrum liso, labio superior delgado, fisuras palpebrales cortas, microcefalia), Turner (cuello alado, linfedema de manos y pies), Noonan, X frágil.
- Ante sospecha de síndrome: buscar malformaciones mayores asociadas (ecocardiograma, ecografía renal), evaluar audición y visión, desarrollo psicomotor.
- Estudio genético (cariotipo, microarray) indicado por genetista.
- Seguimiento: derivar a genética clínica; asesoramiento genético a la familia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 76

Un niño de 14 años, cuyo padre murió de muerte súbita, presenta talla alta, con dedos y extremidades muy largos y algo desproporcionados. Además, presenta hiperlaxitud articular y un soplo diastólico en la auscultación cardíaca. **¿Cuál es el síndrome más probable?**

A Neurofibromatosis
B Síndrome alcohólico fetal
C Síndrome de Miller
D Síndrome de Marfan
E Síndrome de Ehlers-Danlos

Respuesta D. Talla alta con extremidades largas (dolicostenomelia), aracnodactilia, hiperlaxitud, soplo diastólico (insuficiencia aórtica por dilatación de la raíz) y antecedente familiar de muerte súbita (disección aórtica) es síndrome de Marfan, autosómico dominante por mutación de fibrilina 1. Ehlers-Danlos da hiperlaxitud y piel hiperelástica, pero sin hábito marfanoide.

▶ VER CLASE 2.01.1.133 Malformaciones congénitas más frecuentes

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.3 · Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

QUÉ HAY QUE SABER

- Malformaciones congénitas más frecuentes: cardiopatías congénitas, defectos del tubo neural (mielomeningocele, anencefalia), fisura labiopalatina, hipospadias, pie bot, displasia de caderas.
- Prevención de defectos del tubo neural: ácido fólico 0,4 mg/día periconcepcional (4 mg si antecedente) y fortificación de harina con ácido fólico en Chile.
- Digestivas: atresia esofágica (polihidroamnios, sialorrea, imposibilidad de pasar sonda, fístula traqueoesofágica), atresia duodenal (doble burbuja, síndrome de Down), gastrosquisis y onfalocele, hernia diafragmática (abdomen excavado, ruidos intestinales en tórax), malformación anorrectal.
- Manejo inicial: mielomeningocele cubrir con gasa estéril húmeda y posición prona; gastrosquisis cubrir con bolsa plástica estéril; hernia diafragmática: no ventilar con mascarilla, intubar y sonda orogástrica.
- Cardiopatías congénitas operables, fisura labiopalatina y disrafias espinales son GES.
- Seguimiento: derivar al especialista correspondiente (cirugía infantil, neurocirugía, cardiología) y a genética si es sindrómica.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 19

Recién nacido presenta marcada dificultad respiratoria. Al examen físico tiene abolición del murmullo pulmonar izquierdo y se auscultan los ruidos cardíacos desplazados hacia el lado derecho. Su abdomen está excavado. **¿Cuál es la conducta inicial?**

A Cirugía de urgencia
B Realizar intubación orotraqueal
C Realizar toracostomía de urgencia
D Administrar prostaglandinas y oxígeno al 100 por ciento
E Ventilación a presión positiva por mascarilla

Respuesta B. Dificultad respiratoria grave, murmullo pulmonar ausente de un lado, ruidos cardíacos desplazados y abdomen excavado: hernia diafragmática congénita. La conducta inicial es intubar y ventilar; la reparación quirúrgica es diferida. La mascarilla con presión positiva está contraindicada, porque distiende más las asas dentro del tórax.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 153

Un recién nacido de 40 semanas de edad gestacional, presenta disnea importante al nacer, con taquipnea marcada, cianosis y desaturación arterial. Presenta ruidos cardiacos desplazados al lado izquierdo, con ruidos intestinales en el lado derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra asas intestinales en el hemitórax derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar cirugía de urgencia
B Solicitar endoscopía digestiva alta
C Administrar oxígeno en alta concentración, por mascarilla
D Administrar prostaglandina
E Realizar intubación orotraqueal y conectar a ventilador mecánico

Respuesta E. Es una hernia diafragmática. Produce hipoplasia pulmonar. Se debe intubar, conectar al ventilador de alta frecuencia y probablemente a la membrana de oxigenación extracorpórea y la cirugía se postpone, para cuando esté estable, con los pulmones más desarrollados. Eso es pregunta para especialistas, no para médico general.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 74

Un recién nacido de término presenta dificultad respiratoria severa y progresiva. Al examen físico se aprecia abdomen excavado y se auscultan ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra niveles hidroaéreos en el hemitórax izquierdo. ¿Cuál es la secuela más importante de esta patología?

A Estenosis traqueal
B Compresión hepática
C Estenosis intestinal
D Compresión del ventrículo izquierdo
E Hipoplasia pulmonar

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Hipoplasia pulmonar). La hernia diafragmática congénita se complica con hipoplasia pulmonar que puede ser muy grave.

▶ VER CLASE 2.01.1.134 **Trisomía 21** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.26 · Genética y Dismorfias: Síndrome de Down (Trisomía 21) y Síndromes Genéticos Frecuentes

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome de Down (trisomía 21): la anomalía cromosómica más frecuente; riesgo aumenta con edad materna. Confirmar con cariotipo (trisomía libre 95%, translocación ~4%: estudiar padres).
- Fenotipo: hipotonía, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, epicanto, perfil facial plano, pliegue palmar único, braquicefalia, sandal gap, manchas de Brushfield, discapacidad intelectual.
- Malformaciones a buscar al nacer: cardiopatía (~50%, canal AV la más típica): ecocardiograma a todos; digestivas (atresia duodenal, Hirschsprung); cataratas congénitas.
- Seguimiento según guía: TSH al nacer, a los 6 y 12 meses y luego anual (hipotiroidismo); hemograma (leucemia, reacción leucemoide); audición y oftalmología periódicos; celiaquía; inestabilidad atlantoaxial; apnea del sueño.
- Manejo inicial: comunicación empática del diagnóstico, apoyo a lactancia, estimulación temprana, vacunas habituales.
- Seguimiento: derivar a genética, cardiología y equipo multidisciplinario; curvas de crecimiento específicas para síndrome de Down.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un recién nacido de término presenta hipotonía, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, epicanto, pliegue palmar único y occipucio plano. Se sospecha síndrome de Down y se solicita cariograma. **Además del cariograma, ¿qué examen debe realizarse precozmente en todo recién nacido con esta sospecha?**

A Resonancia magnética cerebral
B Electroencefalograma
C Radiografía de columna cervical
D Ecocardiograma
E Densitometría ósea

Respuesta D. Cerca de la mitad de los niños con síndrome de Down tiene cardiopatía congénita, siendo característico el canal auriculoventricular, que puede ser asintomático al nacer y causar hipertensión pulmonar precoz. Por ello se indica ecocardiograma a todos en el período neonatal. También se controlan hemograma, función tiroidea, audición y visión.

▶ VER CLASE 2.01.1.136 **Depresión** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.1 · Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Depresión infantojuvenil: en niños predomina irritabilidad, quejas somáticas, baja del rendimiento escolar, aislamiento; en adolescentes ánimo bajo, anhedonia, alteraciones de sueño y apetito, ideación suicida.
- Criterio: síntomas la mayor parte del día por ≥2 semanas con deterioro funcional (DSM-5). Depresión en ≥15 años es GES.
- Siempre preguntar directamente por ideación suicida, consumo de sustancias, abuso, bullying y problemas familiares.
- Manejo inicial: psicoeducación, intervención psicosocial, activación conductual, higiene de sueño; psicoterapia (cognitivo-conductual) es primera línea en leve-moderada.
- Fármaco de elección en adolescente moderada-grave: fluoxetina 10-20 mg/día; vigilar aumento de ideación suicida al inicio (advertencia en <25 años).
- Seguimiento: derivar a psiquiatría infantojuvenil si grave, con riesgo suicida, psicosis, bipolaridad o falta de respuesta; control frecuente al inicio del tratamiento.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una adolescente de 15 años presenta desde hace 2 meses ánimo bajo e irritable, anhedonia, insomnio, baja de rendimiento escolar, aislamiento y sentimientos de culpa. Niega ideación suicida. Ha recibido 8 sesiones de psicoterapia sin mejoría y los síntomas son de intensidad moderada a grave. **¿Cuál es el fármaco de elección?**

A Amitriptilina
B Fluoxetina
C Clonazepam
D Litio
E Quetiapina

Respuesta B. Depresión moderada a grave en adolescentes que no responde a psicoterapia requiere agregar antidepresivo. El de elección, con mejor evidencia y recomendado por la guía GES de depresión, es la fluoxetina, manteniendo psicoterapia y vigilando ideación suicida al inicio. Los tricíclicos no son eficaces en adolescentes y son letales en sobredosis.

▶ VER CLASE 2.01.1.137 Ideación suicida

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.3 · Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización

QUÉ HAY QUE SABER

- Ideación suicida en adolescentes: el suicidio es una de las principales causas de muerte entre 15-24 años. Preguntar directamente no aumenta el riesgo.
- Factores de riesgo: intento previo (el más importante), depresión, consumo de alcohol/drogas, abuso sexual, bullying, disforia de género, conflictos familiares, acceso a medios letales, impulsividad.
- Evaluar severidad (escala Columbia): ideación pasiva, ideación activa con plan, intención, acceso a medios, intentos previos.
- Riesgo alto (plan estructurado, intento reciente, intención, psicosis): no dejar solo, hospitalizar o derivar a urgencia psiquiátrica; involucrar a los padres.
- Medidas: restringir acceso a medios letales (fármacos, armas), plan de seguridad, red de apoyo, tratar depresión y consumo; Salud Responde/línea de prevención.
- Seguimiento: derivar a psiquiatría infantojuvenil; control precoz (en días) tras evaluación o alta.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un adolescente de 16 años es traído por su madre, que encontró una carta de despedida. En la entrevista a solas reconoce que desde hace semanas piensa en morir, ha planificado tomar los medicamentos de su abuela este fin de semana y no ve otra salida. Tiene antecedente de un intento previo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar fluoxetina y control en 2 semanas
B Derivar a psicólogo en atención primaria
C Hospitalización o evaluación psiquiátrica urgente, sin dejarlo solo
D Firmar un contrato de no suicidio y enviar a domicilio
E Mantener la confidencialidad y no informar a la madre

Respuesta C. Ideación suicida con plan estructurado, método accesible, intención, carta de despedida e intento previo constituyen riesgo suicida alto. Requiere evaluación psiquiátrica urgente y, en general, hospitalización, con supervisión permanente y restricción de medios letales. En riesgo vital se rompe la confidencialidad para informar a la familia. Los contratos de no suicidio no son efectivos.

▶ VER CLASE 2.01.1.138 Maltrato infantil

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.28 · Pediatría Psicosocial: Maltrato Infantil, Entrevista Clínica, Conductas de Riesgo en el Adolescente y Psiquiatría de Enlace

QUÉ HAY QUE SABER

- Maltrato infantil: físico, psicológico, negligencia y abuso sexual. Sospechar si relato inconsistente con las lesiones o el desarrollo, consulta tardía, lesiones de distinta data.
- Lesiones sugerentes: equimosis en zonas no prominentes (orejas, cuello, glúteos, genitales), con forma de objeto, quemaduras en guante/calcetín o por cigarro; fracturas metafisarias, costales posteriores o múltiples en lactantes.
- Síndrome del niño sacudido: lactante con compromiso de conciencia, hematoma subdural y hemorragias retinianas sin trauma explicado.
- Estudio: examen completo con registro detallado; en <2 años serie ósea, fondo de ojo y neuroimagen; hemograma y coagulación para descartar diátesis.
- Manejo: proteger al niño (hospitalizar si riesgo), tratar lesiones; la denuncia es obligatoria para el médico (Fiscalía, Carabineros, PDI) y solicitar medida de protección en Tribunal de Familia; en abuso sexual agudo, peritaje en SML.
- Seguimiento: derivar a equipo psicosocial y red de protección (OPD); no confrontar al presunto agresor ni reexaminar innecesariamente.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 150

Un lactante de 6 meses es traído por su madre porque presenta epistaxis. La madre, de 17 años, refiere que se cayó de la cama. Al examen está poco reactivo y presenta múltiples equimosis, algunas de color morado y otras de color verde. Además, tiene dos fracturas costales posteriores. Su TAC de cerebro muestra un hematoma subdural. **¿Qué examen es más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?**

A PTH y calcio
B Tiempos de coagulación
C Exámenes para descartar osteogénesis imperfecta
D Fondo de ojo
E Ecografía abdominal

Respuesta D. Lesiones en distinto estado de evolución, fracturas costales posteriores y hematoma subdural en un lactante con un mecanismo que no las explica son altamente sugerentes de maltrato físico (traumatismo craneal por abuso o niño sacudido). El fondo de ojo busca hemorragias retinales, muy características. Además de estabilizar y tratar el hematoma, debe protegerse al niño y denunciarse.

▶ VER CLASE 2.01.1.139 Trastornos de alimentación

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.18 · Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Anorexia nerviosa: restricción alimentaria con peso significativamente bajo (en niños P/T o IMC <p5), miedo intenso a engordar y distorsión de la imagen corporal; subtipo restrictivo o purgativo.
- Signos somáticos: bradicardia, hipotensión ortostática, hipotermia, lanugo, piel amarillenta (hipercarotenemia), amenorrea, osteopenia.
- Bulimia nerviosa: atracones y conductas compensatorias (vómitos, laxantes, ejercicio) ≥1 vez/semana por 3 meses, peso normal o sobrepeso; erosión dental, hipertrofia parotídea, signo de Russell, hipokalemia con alcalosis metabólica.
- Hospitalizar si: IMC muy bajo o pérdida >20% en 3 meses, bradicardia grave o arritmias, hipotensión, QTc >460 ms, hipokalemia, hipofosfemia, hipoglicemia, rechazo total de alimentación o riesgo suicida.
- Realimentación gradual con control de fósforo, potasio y magnesio por riesgo de síndrome de realimentación (hipofosfemia grave).
- Seguimiento: derivar a psiquiatría infantojuvenil con equipo multidisciplinario (nutrición, psicología, pediatría); ECG y electrolitos en evaluación inicial.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una adolescente de 15 años ha bajado 12 kg en 5 meses mediante restricción alimentaria y ejercicio excesivo. Se percibe gorda pese a tener IMC de 15. Tiene amenorrea de 3 meses. Al examen: FC 42/min, PA 80/50 mmHg, temperatura 35,6 °C y ortostatismo. Exámenes: potasio 2,9 mEq/L y fósforo 2,4 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Manejo ambulatorio con nutricionista y psicólogo
B Indicar anticonceptivos orales por la amenorrea
C Iniciar fluoxetina y control en un mes
D Indicar suplemento hipercalórico en domicilio y control en 2 semanas
E Hospitalizar para estabilización médica y realimentación progresiva

Respuesta E. Anorexia nerviosa con inestabilidad médica (bradicardia menor a 50/min, hipotensión, hipotermia, ortostatismo, hipokalemia e hipofosfemia) es indicación de hospitalización. La realimentación debe ser progresiva y monitorizada por riesgo de síndrome de realimentación (hipofosfemia, hipokalemia, arritmias e insuficiencia cardíaca), con equipo multidisciplinario. Los anticonceptivos no tratan la amenorrea hipotalámica.

▶ VER CLASE 2.01.1.140 Trastornos de ansiedad generalizada

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.7 · Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno de ansiedad generalizada: preocupación excesiva y difícil de controlar sobre múltiples temas (colegio, salud, familia) ≥6 meses, con ≥1 síntoma físico en niños (inquietud, fatiga, irritabilidad, tensión, insomnio).
- Otros trastornos ansiosos infantiles: ansiedad de separación (el más frecuente en niños pequeños), fobia específica, fobia social, mutismo selectivo, crisis de pánico en adolescentes.
- Presentación frecuente con síntomas somáticos (dolor abdominal, cefalea) y rechazo escolar; descartar hipertiroidismo, consumo de cafeína o drogas, asma mal controlada.
- Manejo inicial: psicoeducación a niño y padres, terapia cognitivo-conductual (primera línea), técnicas de relajación, coordinación con el colegio.
- Fármaco en moderado-grave o sin respuesta a psicoterapia: ISRS (sertralina, fluoxetina) por especialista; evitar benzodiazepinas.
- Seguimiento: derivar a psicología/psiquiatría infantojuvenil si persistente, con deterioro funcional o comorbilidad (depresión).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 10 años presenta desde hace 8 meses preocupación excesiva y difícil de controlar por su rendimiento escolar, la salud de sus padres y eventos futuros. Se asocia a inquietud, dolor abdominal recurrente, cefalea tensional e insomnio de conciliación. Su examen físico es normal y el estudio de dolor abdominal fue negativo. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A Clonazepam diario
B Metilfenidato
C Terapia cognitivo-conductual
D Risperidona
E Propranolol

Respuesta C. Preocupación excesiva y generalizada, de más de 6 meses, con síntomas somáticos (dolor abdominal, cefalea, insomnio), corresponde a trastorno de ansiedad generalizada. En niños, el tratamiento de primera línea es la terapia cognitivo-conductual, incluyendo a la familia; si es moderado a grave o no responde, se agrega un ISRS. Las benzodiacepinas no se recomiendan de mantención en niños.

▶ VER CLASE 2.01.1.141 Trastornos del desarrollo

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.2 · Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastornos del neurodesarrollo: trastorno del espectro autista (TEA), discapacidad intelectual, TDAH, trastornos del lenguaje, del aprendizaje y motores.
- TEA: déficit persistente de comunicación e interacción social + conductas repetitivas e intereses restringidos, desde la infancia temprana; sospechar si no hay contacto visual, no responde al nombre, no señala con el dedo a los 12-14 meses, no juego simbólico, regresión del lenguaje.
- Tamizaje con M-CHAT-R/F entre 16-30 meses y pauta de señales de alerta en controles; siempre evaluar audición.
- Discapacidad intelectual: déficit cognitivo y adaptativo con inicio en el desarrollo; buscar causa (X frágil, síndromes genéticos, hipotiroidismo, TORCH).
- Manejo inicial: intervención temprana (Chile Crece Contigo), apoyo familiar, estimulación del lenguaje, integración escolar (PIE).
- Seguimiento: derivar a neurología/psiquiatría infantil para confirmación diagnóstica y a equipo multidisciplinario (fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología).

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 78

Un niño de 5 años presenta movimientos repetitivos con las manos, estereotipados (manierismos), no habla y solo se comunica con señas, no se relaciona con otros niños y llora cuando le quitan el sombrero. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Trastorno generalizado del desarrollo
B Trastorno por déficit atencional
C Trastorno de conducta
D Hipotiroidismo congénito
E Epilepsia generalizada

Respuesta A. Estereotipias, ausencia de lenguaje, falta de interacción social y rigidez ante cambios configuran un trastorno del espectro autista, que antes se clasificaba dentro de los trastornos generalizados del desarrollo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 47

Un niño de 5 años, al que le molestan los ruidos fuertes, presenta vocabulario muy escaso. Caminó a los 24 meses y dijo su primera palabra a los 36 meses. No pareciera tener interés en relacionarse con los demás niños de su edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno por déficit atencional
B Trastorno generalizado del desarrollo
C Parálisis cerebral
D Distrofia muscular
E Trastorno del lenguaje

Respuesta B. Tiene un trastorno del espectro autista clásico, de la variante autista (Asperger, en cambio, tiene lenguaje normal). Además, afecta otras áreas del desarrollo, por lo que antes se les llamaba trastornos generalizados del desarrollo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 37

Niña que no se comunica con compañeros, responde agresivamente ante cambios en sus rutinas y guarda muñecas sin jugar con ellas. ¿Diagnóstico más probable?

A Trastorno por déficit atencional con hiperactividad
B Trastorno de ansiedad generalizada
C Trastorno del espectro autista
D Trastorno de conducta
E Retraso global del desarrollo

Respuesta C. Diagnóstico: Trastorno del espectro autista (opción C). Trastorno del espectro autista.

▶ VER CLASE 2.01.1.142 Trastornos neuropsiquiátricos

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Psiquiatría** 17.18 · Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastornos neuropsiquiátricos infantojuveniles: TDAH, TEA, tics y síndrome de Tourette, trastorno oposicionista desafiante y de conducta, TOC, trastornos de la conducta alimentaria.
- TDAH: ≥6 síntomas de inatención y/o hiperactividad-impulsividad ≥6 meses, inicio antes de los 12 años, en ≥2 contextos con deterioro; primera línea farmacológica metilfenidato.
- Tics: motores o vocales, repetitivos, transitorios en la mayoría; Tourette si tics motores múltiples y ≥1 vocal por >1 año. Se asocia a TDAH y TOC.
- Trastorno de conducta (violación de normas, agresividad, crueldad) y oposicionista desafiante (desobediencia, irritabilidad): pesquisar maltrato y consumo; intervención familiar y entrenamiento parental.
- TCA (anorexia, bulimia): evaluar estabilidad médica (FC, PA, ECG, electrolitos) y hospitalizar si inestable.
- Seguimiento: derivar a psiquiatría o neurología infantojuvenil para confirmación y tratamiento; trabajo coordinado con familia y colegio.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 9 años presenta desde hace 18 meses parpadeo repetitivo, muecas faciales y movimientos bruscos del cuello, además de carraspeo y emisión de sonidos guturales. Los movimientos aumentan con el estrés, disminuyen al concentrarse y puede suprimirlos brevemente. Su examen neurológico es normal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Corea de Sydenham
B Trastorno obsesivo compulsivo
C Epilepsia mioclónica juvenil
D Síndrome de Tourette
E Distonía aguda

Respuesta D. Tics motores múltiples y al menos un tic vocal, de más de 1 año de evolución, iniciados antes de los 18 años, que pueden suprimirse voluntariamente en forma transitoria, corresponden a síndrome de Tourette. Se asocia frecuentemente a TDAH y TOC. La corea de Sydenham da movimientos irregulares no suprimibles tras una infección estreptocócica; las mioclonías epilépticas no son suprimibles.

▶ VER CLASE 2.01.1.143 Artritis idiopática juvenil

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Reumatología** 9.5 · Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) y Enfermedad de Still del Adulto

QUÉ HAY QUE SABER

- Artritis idiopática juvenil: artritis de causa desconocida en <16 años que persiste ≥6 semanas, tras descartar otras causas.
- Subtipos: oligoarticular (≤4 articulaciones, la más frecuente, niñas pequeñas, rodilla; ANA+ con riesgo de uveítis anterior asintomática), poliarticular (≥5) y sistémica (fiebre en picos diaria, exantema evanescente asalmonado, serositis, hepatoesplenomegalia).
- Rigidez matinal, cojera, aumento de volumen articular sin dolor intenso; diferencial con artritis séptica, reactiva, leucemia (dolor óseo nocturno, citopenias), Lyme.
- Estudio inicial: hemograma, VHS, PCR, ANA, factor reumatoide, Rx de articulaciones comprometidas; descartar leucemia antes de corticoides.
- Manejo inicial: AINE (naproxeno 10-20 mg/kg/día, ibuprofeno); metotrexato, infiltraciones y biológicos por especialista. AIJ es GES.
- Seguimiento: derivar a reumatología pediátrica; control oftalmológico periódico con lámpara de hendidura (uveítis); kinesioterapia; síndrome de activación macrofágica en sistémica es urgencia.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una paciente de 17 años presenta fiebre intermitente de 3 semanas de evolución, acompañada en algunas oportunidades de un rash eritematoso macular, que compromete el tronco y la zona proximal de las extremidades que desaparece al ceder la fiebre. No presenta otros síntomas. Al examen físico se constata artritis del tobillo derecho y de la tercera y cuarta articulaciones metacarpofalángicas izquierdas. Destaca elevación importante de la ferritina plasmática. **El diagnóstico más probable es:**

A Lupus infantil
B Púrpura de Henoch-Schönlein
C Enfermedad de Kawasaki
D Artritis juvenil idiopática (Enfermedad de Still)
E Poliangeítis microscópica

Respuesta D. La asociación de fiebre intermitente prolongada en agujas, exantema macular evanescente que aparece con los picos febriles y desaparece al ceder la temperatura, artritis periférica y marcada elevación de ferritina es patognomónica de la AIJ sistémica o Enfermedad de Still.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niña de 3 años es traída por su madre por presentar claudicación y aumento de volumen en la rodilla derecha de 8 semanas de evolución, sin antecedente traumático ni fiebre. Al examen físico destaca derrame articular moderado en la rodilla derecha sin calor ni eritema, con flexión conservada. No tiene lesiones en piel. Sus exámenes muestran hemograma y PCR normales, con anticuerpos antinucleares (ANA) positivos a título 1:320. **Además de iniciar antiinflamatorios no esteroidales, ¿cuál es la conducta más adecuada e indispensable?**

A Iniciar antibióticos endovenosos para artritis séptica

B Derivar a oftalmología para examen periódico con lámpara de hendidura

C Iniciar pulsos de metilprednisolona por sospecha de Still

D Solicitar radiografía de tórax y factor reumatoide

E Indicar reposo en cama estricto sin controles adicionales

Respuesta B. Paciente con AIJ oligoarticular (artritis de una articulación por > 6 semanas en menor de 16 años) y ANA positivos. Este subgrupo presenta un riesgo muy alto de desarrollar uveítis anterior crónica asintomática, que puede conducir a ceguera irreversible si no se pesquisa tempranamente. El tamizaje periódico con lámpara de hendidura por oftalmología es mandatorio.

Situaciones clínicas de urgencia

28 códigos

▶ VER CLASE 2.01.2.001 **Abdomen agudo** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.12 · Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal

QUÉ HAY QUE SABER

- Abdomen agudo pediátrico: causa quirúrgica más frecuente es apendicitis aguda (peak escolares): dolor periumbilical que migra a fosa ilíaca derecha, anorexia, vómitos, fiebre, signos peritoneales. En <5 años se perfora con mayor frecuencia.
- Invaginación intestinal: lactante 3 meses-3 años, crisis de llanto con dolor cólico intermitente, flexión de piernas, vómitos, masa en morcilla, deposiciones en jalea de grosella; ecografía (signo de diana); reducción hidrostática o neumática si no hay peritonitis.
- Otras: vólvulo por malrotación (vómitos biliosos en lactante: urgencia), hernia atascada, torsión testicular/ovárica, divertículo de Meckel, obstrucción por bridas.
- Causas médicas que simulan: adenitis mesentérica, neumonía basal, gastroenteritis, constipación, ITU, cetoacidosis diabética, PSH.
- Manejo inicial: régimen cero, hidratación EV, analgesia (no enmascara el diagnóstico), exámenes (hemograma, PCR, orina) y ecografía abdominal; evitar laxantes y enemas.
- Seguimiento: derivar a cirugía infantil de urgencia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 8 meses, previamente sano, con crisis de llanto intenso y encogimiento de piernas cada 15 a 20 minutos desde hace 8 horas; entre las crisis está pálido y decaído. Ha vomitado 3 veces y hace 1 hora tuvo una deposición con sangre y mucosidad. Se palpa una masa alargada en el hemiabdomen derecho. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y su manejo inicial?**

A Invaginación intestinal; ecografía abdominal y reducción con enema hidrostático o neumático

B Cólico del lactante; tranquilizar y control

C Diarrea disentérica; cotrimoxazol oral

D Estenosis hipertrófica del píloro; piloromiotomía

E Apendicitis aguda; apendicectomía sin estudio

Respuesta A. Crisis de dolor cólico intermitente con palidez entre episodios, vómitos, deposición en jalea de grosella y masa palpable entre los 3 y 24 meses es invaginación intestinal. La ecografía muestra la imagen en diana y, sin peritonitis ni perforación, se reduce con enema; si falla, cirugía.

▶ VER CLASE 2.01.2.002 **Absceso amigdalino** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.14 · Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

QUÉ HAY QUE SABER

- Absceso periamigdalino: complicación de amigdalitis en adolescentes; odinofagia intensa unilateral, disfagia, sialorrea, trismus, voz «de papa caliente», fiebre.
- Examen: abombamiento del pilar anterior y paladar blando unilateral, desviación de la úvula al lado contrario. Diferencial con flegmón periamigdalino (sin colección).
- Absceso retrofaríngeo (<5 años): fiebre, tortícolis, rigidez cervical con dolor a la extensión, disfagia, estridor; Rx lateral de cuello con ensanchamiento prevertebral; TC con contraste.
- Manejo: punción-aspiración o drenaje por ORL, antibiótico EV (penicilina sódica + metronidazol, ampicilina-sulbactam o clindamicina), analgesia, hidratación, corticoides puede considerarse.
- Banderas rojas: compromiso de vía aérea, extensión a espacio parafaríngeo o mediastino (mediastinitis), síndrome de Lemierre.
- Seguimiento: derivar a ORL de urgencia; amigdalectomía si absceso recurrente.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un adolescente de 15 años con odinofagia de 5 días, tratada con paracetamol, presenta empeoramiento con odinofagia unilateral intensa, fiebre, trismus, sialorrea y voz apagada (en papa caliente). Al examen se observa abombamiento del pilar amigdalino izquierdo con desplazamiento de la úvula hacia la derecha. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Amoxicilina oral y control en 48 horas

B Drenaje del absceso (punción o incisión) y antibiótico

C Amigdalectomía de urgencia

D Corticoides endovenosos como único tratamiento

E Solicitar TAC y diferir el drenaje una semana

Respuesta B. Odinofagia unilateral, trismus, voz en papa caliente y desplazamiento de la úvula contralateral son el absceso periamigdalino, la complicación supurativa más frecuente de la faringoamigdalitis en adolescentes. El tratamiento es drenaje (punción aspirativa o incisión) más antibiótico (ej. amoxicilina-ácido clavulánico o clindamicina) y analgesia. El TAC se reserva si se sospecha extensión profunda.

▶ VER CLASE 2.01.2.003 Aspiración cuerpo extraño

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.8 · Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Aspiración de cuerpo extraño: peak 1-3 años (maní, frutos secos, piezas pequeñas). Antecedente de episodio de asfixia/atoro con tos súbita es el dato más importante.
- Clínica en bronquio: tos, sibilancias unilaterales, disminución del murmullo localizada; puede pasar a fase asintomática y luego neumonía recurrente en el mismo lóbulo. Laríngeo/traqueal: estridor, disfonía, dificultad respiratoria grave.
- Rx tórax en inspiración y espiración (o decúbito lateral): atrapamiento aéreo e hiperinsuflación unilateral; la mayoría de cuerpos extraños es radiolúcido (Rx normal no descarta).
- Obstrucción completa: lactante <1 año, 5 golpes en la espalda y 5 compresiones torácicas; >1 año, maniobra de Heimlich; si pierde conciencia, RCP. No hacer barrido digital a ciegas.
- Tratamiento definitivo: broncoscopía rígida ante sospecha clínica aunque la Rx sea normal.
- Prevención: no dar frutos secos a <4-5 años; seguimiento: derivar de urgencia a broncopulmonar/ORL/cirugía.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 85

Una niña de dos años presenta un episodio brusco de tos intensa, asociado a cianosis y disnea, que remite luego de pocos minutos. Persiste luego con tos en salvas y expectoración. Al examen pulmonar se auscultan roncus y sibilancias, mayores en el lado derecho. **La conducta más adecuada es:**

A Solicitar PCR para Bordetella pertussis

B Solicitar TAC de tórax

C Solicitar broncoscopía

D Realizar laringoscopía rígida

E Iniciar antibióticos

Respuesta C. Es un cuerpo extraño bronquial clásico, probablemente en el bronquio derecho. Aunque la radiografía suele ser el primer examen, el manejo y la extracción se hacen con broncoscopía, y una clínica tan categórica la obliga.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 64

Una niña de 3 años presenta tos persistente desde hace 7 días, inicialmente seca, pero que desde hace 3 días se volvió productiva, por lo que se le indicó amoxicilina oral, sin mayor respuesta. Sus signos vitales muestran temperatura 37,1 °C, frecuencia respiratoria 25 por minuto, saturación de oxígeno 97% y frecuencia cardíaca 95 latidos por minuto. Al examen físico, se escucha estridor respiratorio, y se observa tiraje supraesternal y subcostal. En la auscultación respiratoria se constatan sibilancias en el lado derecho, además de oírse el estridor respiratorio. Se solicita radiografía de tórax que muestra atelectasia del lóbulo medio. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Laringitis viral

B Bronquiolitis aguda

C Neumonía atípica

D Cuerpo extraño bronquial

E Traqueítis bacteriana

Respuesta D. Es un cuerpo extraño bronquial clásico, por la localización de las alteraciones: bronquio derecho, con afectación del lóbulo medio. La conducta es la broncoscopía rígida, que es diagnóstica y terapéutica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 35

Un lactante de 10 meses de edad, sin antecedentes, mientras come su almuerzo comienza súbitamente con tos asociado a disminución del esfuerzo respiratorio e hipotonía. **La conducta más adecuada en este caso es:**

A Iniciar reanimación cardiopulmonar

B Exploración digital de su cavidad oral

C Iniciar presión digital en epigastrio

D Dar golpes en la espalda

E Iniciar ventilaciones boca a boca

Respuesta D. Es un cuerpo extraño laríngeo obstructivo en un menor de un año, por lo que se dan cinco golpes en la espalda. Si no funciona, se hacen cinco compresiones en el pecho y se repite la secuencia. Desde el año se hace la maniobra de Heimlich.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 127

Un lactante de 1 año de presenta un ataque súbito de tos, sofocamiento y dificultad respiratoria. Al examen presenta sibilancias y disminución del murmullo pulmonar, con FR: 34x'. El diagnóstico más probable es:

A Neumotórax

B Laringitis aguda

C Bronquitis obstructiva

D Cuerpo extraño bronquial

E Angioedema

Respuesta D. Es el cuadro clásico de aspiración de cuerpo extraño (síndrome de penetración: tos intensa; y luego clínica obstructiva localizada).

▶ VER CLASE 2.01.2.004 Compromiso de conciencia

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 3.4 · Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate

QUÉ HAY QUE SABER

- Compromiso de conciencia: evaluar con escala de Glasgow pediátrica (AVPU rápido); Glasgow ≤8 requiere asegurar vía aérea.
- Manejo inicial: ABCDE, O2, monitorización, glicemia capilar inmediata (hipoglicemia: suero glucosado 10% 2-5 ml/kg EV), vía venosa, temperatura, pupilas.
- Causas (AEIOU-TIPS): intoxicaciones (benzodiazepinas, alcohol, opioides: naloxona), infección SNC (meningitis, encefalitis), TEC (incluido maltrato), convulsión/postictal, metabólicas (hipoglicemia, CAD, hiponatremia, uremia), hipoxia, invaginación (letargia).
- Estudio: glicemia, electrolitos, gases, hemograma, PCR, función renal y hepática, amonio, tóxicos en orina; TC de cerebro si trauma o focalidad; punción lumbar tras estabilizar si sospecha infección.
- Signos de hipertensión endocraneana (triada de Cushing, anisocoria): cabeza 30°, hiperventilación transitoria solo si herniación, manitol o NaCl 3%.
- Seguimiento: hospitalizar en UCI pediátrica y derivar según causa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 3 años es traído a urgencia por somnolencia progresiva desde hace 1 hora. No tiene fiebre ni trauma conocido. Al examen tiene Glasgow 10, pupilas normales y reactivas, sin signos meníngeos ni focalidad, y signos vitales estables. **Después de asegurar vía aérea, ventilación y circulación, ¿cuál es el primer examen a realizar?**

A Glicemia capilar (hemoglucotest)

B TAC de cerebro

C Punción lumbar

D Electroencefalograma

E Niveles de amonio

Respuesta A. En todo niño con compromiso de conciencia, tras el ABC, debe medirse de inmediato la glicemia capilar, porque la hipoglicemia es frecuente (ayuno, intoxicaciones, errores del metabolismo), rápida de diagnosticar y tratable con glucosa endovenosa. Luego se orienta el estudio: tóxicos, electrolitos, gases, neuroimagen o punción lumbar según la sospecha.

▶ VER CLASE 2.01.2.005 Crisis bronquial obstructiva

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.5 · Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Crisis obstructiva bronquial (asma/SBO): evaluar gravedad con score de Tal (<2 años) o Pulmonary Score, saturometría, capacidad de hablar, uso de musculatura accesoria.
- Tratamiento inicial: salbutamol 100 µg/puff 2-4 puff (lactante 2 puff) con aerocámara c/10-20 min por 3-5 veces en la primera hora; O2 para saturación ≥93%.
- Si no responde en la primera hora o crisis moderada-grave: prednisona 1-2 mg/kg/día VO (máx 40 mg) por 3-5 días o metilprednisolona/hidrocortisona EV; bromuro de ipratropio asociado en crisis grave.

- Crisis grave refractaria: sulfato de magnesio 40-50 mg/kg EV en 20 min, nebulización continua; signos de paro: silencio auscultatorio, compromiso de conciencia, cianosis, bradicardia.
- Hospitalizar si saturación <93% tras 2 horas de tratamiento, puntaje grave persistente, apneas o mala adherencia/acceso; Rx tórax solo si sospecha complicación.
- Seguimiento: al alta salbutamol c/4-6 h y corticoide oral, control en 24-48 h en sala IRA; derivar a broncopulmonar si crisis graves o recurrentes.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 6 meses, con 2 días de coriza y tos, presenta ahora dificultad respiratoria. Al examen: FR 58 rpm, sibilancias en toda la espiración auscultadas con fonendoscopio, tiraje subcostal moderado, sin cianosis. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Hospitalización abreviada con salbutamol cada 10 minutos por 1 hora

B Alta con salbutamol cada 6 horas y control en 1 semana

C Hospitalización directa en UCI con ventilación mecánica

D Solicitar radiografía de tórax antes de decidir

E Nebulización con adrenalina racémica y observación

Respuesta A. FR 58 (2 puntos) + sibilancias en toda la espiración (2 puntos) + tiraje subcostal moderado (2 puntos) + sin cianosis (0 puntos) = 6 puntos, moderado. Corresponde hospitalización abreviada con salbutamol cada 10 minutos por 1 hora.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 102

Niño de 7 años con asma en crisis, frecuencia respiratoria 40/min, $SatO_2$ 91%, sibilancias bilaterales, sin uso de musculatura accesoria. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

A Salbutamol inhalado + ipratropio + corticoides sistémicos + oxígeno

B Adrenalina subcutánea

C Intubación orotraqueal inmediata

D Antibióticos EV

E Solo oxígeno y observar

Respuesta A. Crisis asmática moderada: broncodilatadores β2 (salbutamol) + anticolinérgico (ipratropio) + corticoides sistémicos (prednisona oral o hidrocortisona EV) + oxígeno para $SatO_2$ >94%.

▶ VER CLASE 2.01.2.006 Deshidratación

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Gastroenterología 6.1 · Diarrea Aguda y Crónica en el Niño
Pediatría 18.11 · Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico

QUÉ HAY QUE SABER

- Deshidratación: evaluar con 4 signos OMS (conciencia, ojos/lágrimas, boca/sed, pliegue) y llene capilar: sin deshidratación <5%, moderada 5-10%, grave >10% o shock.
- Plan A (sin deshidratación): manejo en domicilio, alimentación habitual, SRO 10 ml/kg por cada deposición líquida y 2 ml/kg por vómito, signos de alarma.
- Plan B (moderada): SRO 50-100 ml/kg en 4 horas en el centro de salud, en pequeñas cantidades frecuentes; si vomita, esperar 10 min y continuar más lento; reevaluar a las 4 h.
- Plan C (grave o shock): SF o Ringer lactato 20 ml/kg EV en bolos rápidos, repetir hasta 60-100 ml/kg; si no hay vía venosa en 90 s, osteoclisis. Fleboclisis por sonda nasogástrica es alternativa (gastroclisis) si no hay acceso.
- Usar SRO de osmolaridad reducida (Na 60-75 mEq/L); evitar bebidas azucaradas y jugos. Controlar electrolitos si grave, hipernatremia sospechada o EV.
- Seguimiento: control en 24 h tras plan B; hospitalizar si plan C, falla de rehidratación oral o vómitos incoercibles.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 161

Lactante de 11 meses presenta diarrea aguda abundante de 2 días de evolución, asociada a decaimiento marcado y tendencia al llanto. Al examen físico está somnoliento, con frialdad de extremidades y llene capilar de 3 segundos. Las mucosas se observan secas. **¿Cuál es la indicación inicial para su hidratación?**

A Sales de hidratación oral

B Suero salino al 0,9 %

C Suero glucosado al 5 %

D Suero glucosalino

E Albúmina endovenosa

Respuesta B. Somnolencia, extremidades frías y llene capilar lento indican shock hipovolémico: deshidratación grave, plan C. Se administran bolos endovenosos de suero fisiológico al 0,9 %, de 20 mL/kg, repitiendo según respuesta. El suero glucosado no expande el intravascular y las sales orales están contraindicadas con compromiso de conciencia.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 9 meses, 8 kg, con diarrea acuosa y vómitos desde hace 12 horas. Al examen está irritable, con los ojos hundidos, la boca seca, y bebe agua con avidez cuando se le ofrece. El signo del pliegue cutáneo desaparece en 1,5 segundos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Sin deshidratación: plan A con sales de rehidratación oral en la casa

B Deshidratación moderada: plan B con sales de rehidratación oral en 4 horas, en el box

C Deshidratación grave: plan C con suero endovenoso

D Indicar loperamida y control en 48 horas

E Régimen cero por 12 horas para reposo digestivo

Respuesta B. Irritabilidad, ojos hundidos, sed intensa y pliegue que desaparece con lentitud (menos de 2 segundos): son al menos dos signos de deshidratación moderada. Corresponde plan B, sales de rehidratación oral 50 a 100 mL/kg en 4 horas, en el box de observación.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 138

Un niño de 6 años, es traído por presentar cuadro de dos días de evolución de diarrea acuosa frecuente, asociado a vómitos, rechazo alimentario y decaimiento. Al examen físico se encuentra somnoliento, frecuencia cardiaca de 110 por minuto, presión arterial de 80/50 mmHg y ojos hundidos. La conducta más adecuada en este caso es:

A Indicar suero glucosalino endovenoso en infusión continua

B Indicar sales de rehidratación oral 200ml luego de cada deposición

C Indicar sales de rehidratación oral 100 ml por kilogramo a beber en 4 horas y luego reevaluar

D Indicar suero fisiológico 20ml por kilogramo a pasar en bolo

E Indicar alimentación normal, con abundantes líquidos y control en 48 horas

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Indicar suero fisiológico 20ml por kilogramo a pasar en bolo (opción D). Tiene estado hemodinámico límite, pero el sopor obliga a hidratar por vía endovenosa, con plan C.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 65

Un lactante de 10 meses es llevado por su madre al servicio de urgencia, debido a vómitos y diarrea abundante desde hace 24 horas. En el examen físico llora sin lágrimas, se observa irritable y sus signos vitales muestran frecuencia cardíaca 150 latidos por minuto y presión arterial 96/68 mmHg. Su peso actual es de 9.300 g, con registro de peso previo hace 6 días de 10 kg. El examen abdominal muestra abdomen sensible sin signos peritoneales y aumento de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar gastroclisis con sales de rehidratación

B Administrar bolo endovenoso de 20 cc/kg de suero hipertónico

C Administrar an2emé2cos y enviar a domicilio con hidratación oral

D Hidratar con sales de rehidratación por vía oral

E Administrar bolo endovenoso de 20 cc/kg de solución salina al 0,9%

Respuesta D. Tiene una diarrea aguda con deshidratación moderada, por lo que se trata con “plan B”, consistente en sales de rehidratación oral, 50-100 cc/Kg en la misma urgencia y reevaluar en 4-6 horas. Al bajar 700 gramos, de un total de 10 kilogramos, corresponde al 7% del peso corporal. La deshidratación se considera leve si es menor al 5%, moderada entre 5% y 10% y severa si es mayor al 10% o si Gene compromiso hemodinámico. En este caso hay taquicardia, pero su presión arterial es incluso alta para la...

▶ VER CLASE 2.01.2.007 **Emergencia hipertensiva** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 4.3 · Síndrome Nefrítico y Glomerulonefritis Postestreptocócica (GNPE)

QUÉ HAY QUE SABER

- Emergencia hipertensiva pediátrica: PA elevada (≥p99 + 5 mmHg o etapa 2) con daño de órgano blanco agudo: encefalopatía (cefalea, vómitos, convulsiones, alteración visual, compromiso de conciencia), insuficiencia cardíaca, IRA. Urgencia hipertensiva: sin daño agudo.
- Causas: renales en su mayoría (GNAPE, SHU, glomerulopatías, cicatrices de pielonefritis), coartación aórtica, feocromocitoma, fármacos/drogas.
- Manejo: hospitalizar en UCI, vía venosa, monitorización; reducir PA ≤25% en las primeras 8 h y normalizar en 24-48 h (descenso brusco causa isquemia cerebral).
- Fármacos EV: labetalol (0,2-1 mg/kg bolo o infusión), nicardipino infusión o nitroprusiato; en GNAPE con sobrecarga, furosemida. Urgencia: nifedipino de acción prolongada, amlodipino o captopril VO.
- Estudio: creatinina, electrolitos, orina completa, hemograma, ECG, ecocardiograma, fondo de ojo, ecografía renal.
- Seguimiento: derivar a nefrología pediátrica para estudio etiológico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 8 años, con faringitis hace 2 semanas, presenta orinas oscuras, edema y cefalea intensa. En urgencia presenta una convulsión tónico-clónica generalizada. La presión arterial es 165/110 mmHg y la glicemia es normal. **Una vez controlada la convulsión, ¿cuál es el manejo más adecuado de la presión arterial?**

A Normalizar la presión arterial en la primera hora

B Solo restricción de sal y líquidos

C Observar sin tratamiento hasta que mejore la función renal

D Captopril oral y control ambulatorio

E Descenso gradual con antihipertensivo endovenoso, bajando no más de 25% en las primeras 8 horas

Respuesta E. Hipertensión grave con daño de órgano blanco (encefalopatía hipertensiva con convulsión) en una glomerulonefritis postestreptocócica es una emergencia hipertensiva. Se trata en unidad de paciente crítico con antihipertensivo endovenoso titulable (labetalol o nicardipino) y furosemida por la sobrecarga de volumen, bajando la PA en forma gradual (no más de 25% en 8 horas) para evitar isquemia cerebral.

▶ VER CLASE 2.01.2.008 Epistaxis

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.11 · Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

QUÉ HAY QUE SABER

- Epistaxis en urgencia: niño sentado e inclinado hacia adelante; compresión bidigital de las alas nasales 10-15 min sin soltar; evaluar estabilidad hemodinámica.
- Mayoría anterior (plexo de Kiesselbach); epistaxis posterior rara en niños.
- Persistente: retirar coágulos, algodón con vasoconstrictor (oximetazolina) y lidocaína, compresión; identificar punto sangrante y cauterizar con nitrato de plata (no bilateral en el tabique).
- Refractaria: taponamiento anterior con gasa vaselinada o material reabsorbible; si falla, sospechar posterior y derivar a ORL.
- Pedir hemograma y coagulación si sangrado abundante, recurrente, otros sangrados o historia familiar. Adolescente varón con epistaxis unilateral y obstrucción: nasoangiofibroma.
- Seguimiento: indicar humidificación y vaselina nasal; control en APS y ORL si recurrente.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un adolescente varón de 14 años consulta por epistaxis recurrentes unilaterales por la fosa derecha, abundantes, asociadas a obstrucción nasal progresiva de ese lado en los últimos meses. A la rinoscopía se observa una masa rojiza en la región posterior de la fosa nasal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Biopsia de la masa en el box

B Cauterización con nitrato de plata

C Estudio con imágenes (TAC o RM con contraste) y derivación a otorrinolaringología, sin biopsiar

D Corticoide nasal y control en 3 meses

E Taponamiento anterior y alta

Respuesta C. Epistaxis recurrente unilateral con obstrucción nasal en un adolescente varón sugiere angiofibroma nasofaríngeo juvenil, un tumor benigno muy vascularizado. Se diagnostica con TAC o RM con contraste y su manejo es quirúrgico, a menudo con embolización previa. La biopsia está contraindicada por el riesgo de hemorragia masiva.

▶ VER CLASE 2.01.2.009 Fracturas

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Traumatología** 12.4 · Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial

QUÉ HAY QUE SABER

- Particularidades del hueso infantil: fracturas en tallo verde, rodete (torus) y lesiones fisarias (clasificación de Salter-Harris I-V; III-V intraarticulares con riesgo de alteración del crecimiento).
- Supracondílea de húmero (la más frecuente del codo, 5-7 años, caída con mano extendida): evaluar pulso radial, perfusión y nervios (interóseo anterior, radial, mediano); riesgo de síndrome compartimental (contractura isquémica de Volkmann).
- Clavícula: la fractura más frecuente en RN (parto) y niños; inmovilización con cabestrillo, consolida rápido.
- Pronación dolorosa (subluxación de cabeza radial): 1-4 años tras tracción del brazo; reducción con supinación-flexión o hiperpronación, sin Rx.
- Manejo inicial: analgesia, inmovilización provisoria con férula, Rx en 2 proyecciones, evaluar neurovascular distal; fractura expuesta: cubrir, cefazolina EV, profilaxis antitetánica y derivar.
- Sospechar maltrato en fracturas en <1 año que no camina, metafisarias, costales posteriores o múltiples de distinta data; seguimiento: derivar a traumatología.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 6 años cae de un columpio sobre la mano con el codo en extensión. Presenta dolor, aumento de volumen y deformidad del codo. La radiografía muestra una fractura supracondílea del húmero desplazada. La mano está pálida, fría y no se palpa el pulso radial. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Inmovilización con yeso braquiopalmar y control en una semana

B Solicitar angiografía y esperar el resultado antes de cualquier maniobra

C Analgesia y cirugía electiva en 7 días

D Reducción e inmovilización urgente, con evaluación vascular inmediata

E Vendaje elástico y elevación de la extremidad

Respuesta D. La fractura supracondílea es la fractura de codo más frecuente en niños. Si está desplazada y hay compromiso vascular (lesión o compresión de la arteria braquial), es una urgencia: se reduce de inmediato, habitualmente en pabellón con fijación percutánea, y se reevalúa el pulso y la perfusión. Si no se resuelve, se explora la arteria.

▶ VER CLASE 2.01.2.010 Hemorragia digestiva

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 5.3 · Hemorragia Digestiva Alta y Baja

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemorragia digestiva en urgencia: confirmar sangrado digestivo verdadero (descartar epistaxis, alimentos rojos, sangre materna deglutida: test de Apt).
- Evaluar estabilidad: FC, PA, llene capilar, conciencia; la taquicardia es el signo más precoz de hipovolemia en niños (hipotensión es tardía).
- Manejo inicial: ABC, 2 vías venosas, bolo SF 20 ml/kg, hemograma, grupo y Rh, coagulación, BUN; transfundir GR 10-15 ml/kg si inestable o Hb <7 g/dL; SNG para lavado en HDA.
- HDA: omeprazol 1 mg/kg EV; sospecha de várices (hipertensión portal): octreotide y antibiótico profiláctico; endoscopía alta dentro de 24 h.
- HDB: lactante con invaginación (dolor cólico, jalea de grosella), Meckel (sangrado masivo indoloro, cintigrafía Tc99), pólipo juvenil, ECN en prematuro.
- Seguimiento: hospitalizar y derivar a gastroenterología/cirugía infantil.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 36

Un niño de 3 años es traído al servicio de urgencia porque desde hace 24 horas presenta diarrea y múltiples episodios de vómitos alimentarios. El día anterior había consultado por lo mismo y recibió sales de rehidratación oral. Sin embargo, persistió con vómitos frecuentes y en el último episodio vomitó sangre. Al examen físico tiene signos de deshidratación y está taquicárdico, con llene capilar normal. **¿Cuál es la causa más probable de su hemorragia digestiva?**

A Gastritis erosiva

B Úlcera gastroduodenal

C Síndrome de Mallory-Weiss

D Lesión de Dieulafoy

E Várices esofágicas rotas

Respuesta C. Hematemesis que aparece después de vómitos repetidos e intensos sugiere síndrome de Mallory-Weiss: desgarro de la mucosa de la unión gastroesofágica. Suele ser autolimitado y se maneja con hidratación, antieméticos e inhibidor de bomba. Las várices requieren hipertensión portal y el Boerhaave es una perforación transmural con dolor y enfisema.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 67

Un lactante de 8 meses, presenta un cuadro de malestar general y vómitos alimenta- rios en varias oportunidades, durante las últimas horas. En el último episodio de vómi- tos, se agregó escasa hematemesis, por lo que acude al servicio de urgencias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Esofagitis péptica

B Esofagitis erosiva

C Síndrome de Mallory Weiss

D Gastritis erosiva

E Gastritis por Helicobacter pylori

Respuesta C. Diagnóstico: Síndrome de Mallory Weiss (opción C). Es un Sd. De Mallory Weiss clásico. :::warning No confundirlos — el manejo es opuesto.

▶ VER CLASE 2.01.2.011 Hipertensión endocraneana

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.6 · Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipertensión endocraneana: cefalea matinal o que despierta, vómitos en proyectil, papiledema, diplopía (VI par), compromiso de conciencia; lactante: fontanela abombada, macrocefalia, ojos en sol poniente.
- Tríada de Cushing (HTA, bradicardia, respiración irregular) y anisocoria indican herniación inminente.
- Causas: tumores de fosa posterior, hidrocefalia (disfunción de válvula derivativa), TEC, meningitis/encefalitis, hemorragia, pseudotumor cerebri.
- Manejo inicial: ABC, cabeza a 30° en línea media, normotermia, normoglicemia, normocapnia, sedoanalgesia; Glasgow ≤8: intubar.

- Terapia hiperosmolar: NaCl 3% 3-5 ml/kg o manitol 0,5-1 g/kg EV; hiperventilación solo transitoria ante herniación; dexametasona si edema vasogénico tumoral. Contraindicada la punción lumbar antes de neuroimagen.
- TC cerebral urgente; seguimiento: derivar a neurocirugía y UCI pediátrica.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 166

Un niño de 4 años presenta cefalea de 1 mes de evolución, mayor en las mañanas, asociada a diplopía. Además, ha presentado náuseas y vómitos alimentarios que han aumentado su frecuencia en el último tiempo. **¿Cuál es la causa más probable de su cefalea?**

A Migraña de presentación atípica
B Cefalea tensional
C Migraña clásica
D Vicio de refracción
E Hipertensión endocraneana

Respuesta E. Cefalea progresiva de predominio matinal, con vómitos y diplopía (paresia del VI par, signo de falsa localización), es un síndrome de hipertensión endocraneana. En un niño obliga a neuroimagen urgente para descartar tumor de fosa posterior, hidrocefalia u otras causas. Las cefaleas primarias no son progresivas ni despiertan con vómitos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 149

Un niño de 6 años entra al colegio hace 4 semanas. Hace 3 semanas inicia cefalea progresiva, más intensa en la mañana. Se agregan náuseas y vómitos escasos y diplopía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Trastorno adaptativo
B Trastorno por ansiedad de separación
C Jaqueca clásica
D Hipertensión endocraneana
E Vicio de refracción

Respuesta D. Diagnóstico: Hipertensión endocraneana (opción D). El predominio matinal, los vómitos y la diplopia orientan a hipertensión endocraneana. Implantación del embarazo fuera del útero.

▶ VER CLASE 2.01.2.012 Insuficiencia cardíaca. Edema pulmonar

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.23 · Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia cardíaca aguda/edema pulmonar pediátrico: dificultad respiratoria, taquipnea, crépitos, taquicardia, ritmo de galope, hepatomegalia, mala perfusión; lactante: sudoración y rechazo alimentario.
- Causas: cardiopatía congénita con cortocircuito o obstrucción (coartación en RN: pulsos femorales ausentes), miocarditis viral, miocardiopatía, arritmias (TPSV), sobrecarga de volumen (GNAPE, IRA).
- Estudio: Rx tórax (cardiomegalia, congestión), ECG, ecocardiograma, gases, electrolitos, troponina y BNP.
- Tratamiento: posición semisentada, O2/ventilación no invasiva, furosemida 1-2 mg/kg EV, restricción de volumen; vasodilatadores y apoyo inotrópico (milrinona, dobutamina) en bajo gasto.
- RN con shock cardiogénico por cardiopatía ductus-dependiente: prostaglandina E1; TPSV: adenosina o cardioversión.
- Seguimiento: hospitalizar en UCI pediátrica y derivar a cardiología infantil.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un escolar de 9 años, que hace 10 días tuvo un cuadro respiratorio viral, consulta por cansancio, disnea progresiva, ortopnea y dolor abdominal. Al examen tiene FC 140/min, ritmo de galope, crepitaciones bibasales y hepatomegalia dolorosa. La radiografía de tórax muestra cardiomegalia y congestión pulmonar. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Miocarditis viral con insuficiencia cardíaca
B Neumonía bilateral
C Crisis asmática
D Pericarditis aguda sin compromiso miocárdico
E Hepatitis viral aguda

Respuesta A. Insuficiencia cardíaca aguda (taquicardia desproporcionada, galope, congestión pulmonar, hepatomegalia y cardiomegalia) en un niño previamente sano tras una infección viral sugiere miocarditis viral. El dolor abdominal por congestión hepática es una forma de presentación frecuente en niños. Se confirma con troponinas, ECG y ecocardiograma; se maneja con diuréticos, soporte y en unidad crítica si hay shock.

▶ VER CLASE 2.01.2.013 Insuficiencia respiratoria aguda

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 5.1 · Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia respiratoria aguda: incapacidad de mantener intercambio gaseoso: PaO2 <60 mmHg (saturación <90%) con FiO2 ambiental (tipo I) y/o PaCO2 >50 mmHg con acidosis (tipo II).
- Signos clínicos: taquipnea, retracción, aleteo nasal, quejido, cabeceo, cianosis, agitación o somnolencia, bradipnea y pausas (signo de agotamiento inminente).
- Causas en niños: bronquiolitis, neumonía, crisis asmática, laringitis/obstrucción alta, cuerpo extraño, enfermedad neuromuscular, depresión del SNC (intoxicaciones).
- Manejo inicial: posición cómoda, aspirar secreciones, O2 para saturación ≥93% (mascarilla con reservorio si grave), tratar causa (broncodilatadores, adrenalina, antibióticos).
- Escalar a cánula nasal de alto flujo, VNI o intubación si hipoxemia refractaria, hipercapnia con acidosis, agotamiento o compromiso de conciencia.
- Seguimiento: hospitalizar y derivar a UCI pediátrica si requiere soporte ventilatorio.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 125

Niño de 3 años hospitalizado por neumonía. Tiene saturación de 88% con oxígeno por naricera a 3 L/min, frecuencia respiratoria de 50/min y uso de musculatura accesoria. **¿Cuál es el siguiente paso en el manejo ventilatorio?**

A Ventilación no invasiva (CPAP) o cánula nasal de alto flujo

B Intubación orotraqueal inmediata

C Aumentar el flujo de oxígeno por naricera a 6 L/min

D Adrenalina nebulizada

E Alta con oxígeno domiciliario

Respuesta A. Hipoxemia persistente con aumento del trabajo respiratorio pese a oxígeno por naricera indica insuficiencia respiratoria aguda en progresión. El siguiente escalón, si está alerta y hemodinámicamente estable, es soporte no invasivo: cánula nasal de alto flujo o CPAP/VNI. La intubación se reserva para falla de estas medidas, compromiso de conciencia o agotamiento.

▶ VER CLASE 2.01.2.014 **Intoxicaciones** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.24 · Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes

QUÉ HAY QUE SABER

- Intoxicaciones: en niños <5 años mayormente accidentales (medicamentos, productos de limpieza, cáusticos); en adolescentes, intencionales (intento suicida) o recreacionales.
- Manejo inicial: ABCDE, glicemia, identificar tóxico, dosis, hora; síndromes toxicológicos: colinérgico (organofosforados: miosis, sialorrea, bradicardia: atropina), anticolinérgico, opioide (miosis, depresión respiratoria: naloxona), simpaticomimético.
- Descontaminación: carbón activado 1 g/kg en la primera hora si vía aérea protegida; contraindicado en cáusticos, hidrocarburos, alcoholes, metales. No inducir vómito.
- Antídotos: paracetamol (N-acetilcisteína según nomograma de Rumack-Matthew a las 4 h), benzodiazepinas (flumazenil con precaución), hierro (deferoxamina), monóxido de carbono (O2 100%/hiperbárica).
- Cáusticos: no neutralizar ni dar carbón; endoscopía en 12-24 h si síntomas. Contactar CITUC (centro de información toxicológica).
- Seguimiento: hospitalizar según tóxico; evaluación psiquiátrica en intento suicida; educación preventiva (almacenamiento seguro).

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 95

Una niña de 5 años ingiere accidentalmente soda cáustica hace 45 minutos. Evoluciona con sialorrea y dolor abdominal y torácico. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Administrar carbón activado

B Solicitar endoscopía digestiva alta

C Administrar un agente alcalinizante

D Instalar una sonda nasogástrica y aspirar el contenido

E Inducir el vómito

Respuesta B. La ingesta de cáustico se estudia con endoscopía digestiva alta precoz: gradúa el daño y decide la conducta. Carbón activado, neutralizantes, sonda para aspirar y provocar el vómito no tienen utilidad o están contraindicados, porque el daño ya ocurrió y esas maniobras lo agravan o reexponen el esófago al cáustico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 108

Un niño de 4 años ingirió hace 24 horas 7 comprimidos de algún medicamento desconocido, evolucionando con malestar general, vómitos e ictericia. Los exámenes muestran GOT 403 UI/L, GPT 390 UI/L y bilirrubina total 5,2 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Administrar L-carnitina endovenosa

B Administrar deferoxamina endovenosa

C Administrar N-acetilcisteína endovenosa

D Administrar carbón activado vía oral

E Administrar piridoxina vía oral

Respuesta C. Vómitos seguidos de daño hepatocelular a las 24 horas de una ingesta medicamentosa sugieren intoxicación por paracetamol, el fármaco más disponible en los hogares. El antídoto es N-acetilcisteína, más efectiva antes de 8 a 10 horas pero indicada aun tardíamente si hay hepatotoxicidad. El carbón activado solo sirve en la primera hora.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 40

Una niña de 2 años ingirió muchas pastillas, que había en la casa. Al examen físico, está inconsciente, pálida e hipotónica, con pulso a 117 por minutos, frecuencia respiratoria de 38 por minuto y pupilas arreactivas a la iluminación. ¿Qué fármacos son los más probablemente ingeridos?

A AINES

B Benzodiacepinas

C Salicilatos

D Opiáceos

E Antidepresivos tricíclicos

Respuesta A. Es una intoxicación por tricíclicos por el compromiso de conciencia, taquicardia y pupilas arreactivas (en midriasis). No puede ser benzodiacepinas ni opiáceos, porque no tenía disminución de la frecuencia respiratoria. AINEs y salicilatos no afectan las pupilas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 81

Niño de 4 años llega a urgencias con miosis puntiforme, bradicardia, hipersecreción (lagrimeo, sialorrea, broncoespasmo) y compromiso de conciencia. Antecedente de acceso a bodega con pesticidas. ¿Cuál es la conducta inmediata?

A Hospitalizar: atropina EV + pralidoxima + lavado gástrico

B Derivar a especialista de forma ambulatoria

C Control sano habitual

D Observación domiciliaria 24h

E Solo anticonvulsivantes EV

Respuesta A. Síndrome colinérgico por organofosforados (pesticida): miosis + bradicardia + hipersecreción + compromiso neurológico = emergencia. Tratamiento: atropina EV a dosis altas (antídoto) + pralidoxima (reactiva AChE si precoz) + hospitalización.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 28

Niño que juega en huerto que evoluciona con sialorrea y miosis a. Intoxicación por organofosforado

A Control sano habitual

B Derivar a especialista

C Hospitalizar

D Observación domiciliaria

E Iniciar tratamiento empírico

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Control sano habitual). 1.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 41

Un niño de edad presenta un cuadro de agitación, alternado con obnubilación, asociado a vómitos, sialorrea, diarrea, dolor abdominal, taquicardia, tos, temblor y sudoración. Se sospecha que haya ingerido algún tóxico. ¿Cuál es la conducta inicial?

A Administrar antieméticos

B Administrar omeprazol

C Administrar solución glucosada al 10%

D Administrar N-acetil.cisteína

E Administrar atropina

Respuesta E. Tiene un síndrome colinérgico clásico (lo más probable es que consumió insecticidas), por lo que debe recibir atropina como antídoto. Revisar los síndromes de las intoxicaciones en psiquiatría.

▶ VER CLASE `2.01.2.015` **Meningitis bacteriana** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.2 · Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

QUÉ HAY QUE SABER

- Meningitis bacteriana: fiebre, cefalea, vómitos, rigidez de nuca, compromiso de conciencia; lactante con irritabilidad, fontanela abombada, convulsiones. Petequias sugieren meningococo.
- Punción lumbar tras estabilizar (TC previa solo si focalidad, papiledema, Glasgow bajo): LCR >1.000 cél/mm³ PMN, glucosa <40 mg/dL, proteínas >100 mg/dL; Gram, cultivo, PCR. Hemocultivos.
- Antibiótico empírico inmediato (no retrasar por PL): >1 mes ceftriaxona 100 mg/kg/día EV + vancomicina 60 mg/kg/día; <1 mes ampicilina + cefotaxima (± gentamicina).
- Dexametasona 0,15 mg/kg c/6 h por 2-4 días antes o con la primera dosis de antibiótico en >6 semanas.
- Duración: meningococo 5-7 días, Hib 7-10, neumococo 10-14, SGB 14-21, gram negativos 21 días. Manejo de shock, convulsiones, SIADH (restricción hídrica relativa si euvolémico).
- Notificación inmediata; quimioprofilaxis a contactos en meningococo y Hib. Seguimiento: potenciales evocados auditivos y control del neurodesarrollo.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 80

Escolar de 10 años con fiebre alta, rigidez de nuca, fotofobia y petequias en piel. Sospecha de meningitis bacteriana. **¿Cuál es el esquema antibiótico empírico de elección?**

A Ceftriaxona + vancomicina EV

B Ciprofloxacino EV

C Doxiciclina oral

D Azitromicina oral

E Amoxicilina oral

Respuesta A. Mayor de 3 meses y menor de 50 años: los agentes son neumococo y meningococo. Esquema empírico: ceftriaxona + vancomicina EV, con dexametasona antes o junto al antibiótico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 137

Lactante de 3 meses con fiebre de 39 °C, rigidez de nuca, fontanela abombada y letargia. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Hospitalizar, realizar punción lumbar e iniciar antibióticos empíricos endovenosos (ampicilina más cefotaxima)

B Indicar antibióticos orales y control en 24 horas

C Solo antipiréticos y observación domiciliaria

D Solicitar una tomografía computada antes de la punción lumbar

E Dar de alta con indicaciones a los padres

Respuesta A. Fontanela abombada, rigidez de nuca y letargia son signos de alarma que sacan a este lactante de cualquier criterio de bajo riesgo: se trata como meningitis bacteriana hasta demostrar lo contrario, con hospitalización, punción lumbar y antibióticos empíricos inmediatos.

▶ VER CLASE 2.01.2.016 **Meningococcemia** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.2 · Meningitis Aguda Bacteriana y Viral

QUÉ HAY QUE SABER

- Meningococcemia (Neisseria meningitidis): fiebre con exantema petequial o purpúrico que progresa rápidamente, compromiso del estado general, shock; puede o no tener meningitis.
- Fiebre y petequias: evaluar urgente; púrpura fulminans y coagulación intravascular diseminada indican gravedad extrema (síndrome de Waterhouse-Friderichsen).
- Manejo inicial: ceftriaxona 100 mg/kg EV o IM inmediata (incluso en APS antes del traslado), sin esperar exámenes; hemocultivos si no retrasa.
- Shock: bolos de cristaloides 10-20 ml/kg, drogas vasoactivas precoces (adrenalina), corregir hipoglicemia y coagulopatía, UCI.
- Notificación inmediata; quimioprofilaxis a contactos íntimos en <24 h: ciprofloxacino 500 mg dosis única (adultos), rifampicina 10 mg/kg c/12 h por 2 días en niños o ceftriaxona IM (embarazadas, niños).
- Prevención: vacuna antimeningocócica conjugada a los 12 meses (PNI). Seguimiento: hospitalizar en UCI y derivar.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una niña de 4 años presenta fiebre de 39,5 °C de 8 horas de evolución, decaimiento y lesiones purpúricas que no blanquean a la presión, que se extienden rápidamente en tronco y extremidades. Al examen tiene FC 160/min, llene capilar de 4 segundos y extremidades frías. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar punción lumbar antes de iniciar antibióticos

B Administrar ceftriaxona endovenosa de inmediato y reanimar con fluidos

C Esperar el resultado del hemograma y la PCR

D Indicar amoxicilina oral y control en 24 horas

E Solicitar TAC de cerebro antes de cualquier tratamiento

Respuesta B. Fiebre con púrpura que progresa rápidamente y signos de shock es meningococcemia (enfermedad meningocócica invasora) hasta demostrar lo contrario, con alta mortalidad en horas. Se inicia ceftriaxona endovenosa (o intraósea) de inmediato, sin esperar exámenes ni punción lumbar, junto con reanimación con fluidos. Es de notificación inmediata y requiere quimioprofilaxis de contactos cercanos.

▶ VER CLASE 2.01.2.017 Muerte súbita-ALTE, BRUE

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Neurología 10.10 · Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas

QUÉ HAY QUE SABER

- BRUE (antes ALTE): episodio súbito, breve (<1 min) y resuelto en lactante <1 año con cianosis o palidez, alteración de respiración, del tono o de la respuesta, sin explicación tras historia y examen.
- BRUE de bajo riesgo: >60 días, EG ≥32 semanas y edad corregida ≥45 semanas, primer episodio, duración <1 min, sin RCP por profesional, examen normal: observación breve, educación y ECG; no requiere hospitalizar.
- Alto riesgo o episodio explicado: estudiar causas: reflujo, infecciones (VRS, coqueluche, sepsis), convulsiones, arritmias (QT largo), maltrato, metabólicas, obstrucción de vía aérea.
- Síndrome de muerte súbita del lactante: muerte inexplicable <1 año, peak 2-4 meses durante el sueño; factores de riesgo: posición prona, colecho, tabaquismo, superficies blandas, sobreabrigo, prematurez.
- Prevención: dormir boca arriba, en cuna propia en la pieza de los padres, colchón firme, sin almohadas ni peluches, sin tabaco, lactancia materna, chupete al dormir.
- Seguimiento: control en 24 h en BRUE de bajo riesgo; derivar los de alto riesgo para hospitalización y estudio; enseñar RCP a los padres.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 162

Un niño de 24 meses ha presentado 3 episodios de llanto de breve duración, seguidos de apnea y luego pérdida de conciencia, recuperándose al poco tiempo. Al examen físico no tiene alteraciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Instruir a los padres en reanimación cardiopulmonar

B Solicitar TAC de cerebro

C Educar a los padres en el manejo de las emociones del niño

D Solicitar electroencefalograma

E Indicar monitor cardíaco

Respuesta C. Llanto o enojo seguido de apnea, cianosis o palidez y breve pérdida de conciencia con recuperación espontánea, entre los 6 meses y 5 años, son espasmos del sollozo (apneas emotivas): eventos benignos sin riesgo vital. Se tranquiliza y educa a los padres y se descarta anemia ferropénica, que los aumenta. No requieren EEG ni neuroimagen.

▶ VER CLASE 2.01.2.018 Obstrucción de vía aérea superior

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Otorrino 14.17 · Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia
Pediatría 18.6 · Laringitis Aguda Obstructiva / Croup: Score de Taussig, Adrenalina Racémica y Dexametasona
Pediatría 18.8 · Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Obstrucción de vía aérea superior: estridor inspiratorio, disfonía, tos perruna, retracción supraesternal; gravedad: estridor en reposo, cianosis, agitación o somnolencia.
- Causas: laringitis (la más frecuente), cuerpo extraño (inicio súbito con atoro), epiglotitis (toxicidad, babeo, posición trípode, sin tos; rara por vacuna Hib), traqueítis bacteriana, absceso retrofaríngeo, anafilaxia.
- Principio clave: no agitar al niño ni examinar la faringe si se sospecha epiglotitis; mantenerlo en brazos de los padres, O2 sin forzar.
- Laringitis: dexametasona 0,15-0,6 mg/kg y nebulización con adrenalina; anafilaxia: adrenalina IM 0,01 mg/kg; cuerpo extraño con obstrucción completa: golpes en espalda/compresiones torácicas o Heimlich.
- Epiglotitis/traqueítis: vía aérea definitiva por el operador más experto (pabellón, ORL/anestesia) y ceftriaxona EV (+ cloxacilina o vancomicina en traqueítis).
- Seguimiento: hospitalizar casos moderados-graves; derivar a ORL/UCI.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un preescolar de 3 años es llevado a urgencia por cuadro de 4 horas con fiebre de 39,8 °C, aspecto tóxico y gran dificultad respiratoria. No tiene tos. Está sentado, inclinado hacia adelante con el cuello extendido, con la boca entreabierta y abundante sialorrea. Emite un estridor inspiratorio apagado. **¿Cuál de las siguientes acciones está formalmente contraindicada?**

A Oxígeno suplementario humidificado sin invadir al paciente

B Traslado inmediato a pabellón con un anestesiólogo

C Deprimir la lengua con un abatelenguas para inspeccionar la faringe

D Ceftriaxona endovenosa una vez asegurada la vía aérea

E Mantener a la madre junto al niño para evitar el llanto

Respuesta C. Es una epiglotitis aguda: fiebre tóxica, babeo, postura en trípode y ausencia de tos. Deprimir la lengua puede desencadenar laringoespasmo y paro cardiorrespiratorio. Se debe asegurar la vía aérea en pabellón.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 4 años, sin vacunas desde el año de vida, con fiebre de 39,8 °C de 6 horas. Llega sentado inclinado hacia adelante con el cuello extendido, babeando, con estridor inspiratorio suave y aspecto tóxico. No tiene tos perruna. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Examinar la faringe con bajalenguas para confirmar el diagnóstico

B Mantenerlo tranquilo con su madre, dar oxígeno sin incomodarlo y asegurar la vía aérea en pabellón con anestesista

C Acostarlo para tomar una radiografía lateral de cuello

D Dexametasona oral y alta con control en 24 horas

E Nebulizar adrenalina y observar 4 horas en urgencia

Respuesta B. Fiebre alta, aspecto tóxico, sialorrea, posición en trípode y ausencia de tos perruna en un niño no vacunado sugieren epiglotitis por Haemophilus influenzae tipo b. No se examina la faringe ni se acuesta al niño: se asegura la vía aérea en pabellón y luego se inicia ceftriaxona.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 7 meses, en brazos de su madre comiendo puré, comienza súbitamente con tos intensa. A los pocos segundos deja de toser, no llora, no emite sonidos, y presenta cianosis progresiva con tiraje universal. **¿Cuál es la maniobra indicada en este momento?**

A Maniobra de Heimlich con 5 compresiones abdominales

B 5 golpes interescapulares seguidos de 5 compresiones torácicas

C Barrido digital a ciegas de la cavidad oral

D Ventilaciones boca a boca de inmediato

E Observar y esperar a que el objeto salga solo

Respuesta B. Obstrucción completa en un lactante menor de 1 año: la maniobra indicada es 5 golpes interescapulares seguidos de 5 compresiones torácicas. La maniobra de Heimlich está contraindicada a esta edad por el riesgo de lesión hepática o esplénica.

▶ VER CLASE 2.01.2.019 **Obstrucción intestinal** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Gastroenterología 6.3 · Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones
Pediatría 18.12 · Vómitos en el Lactante: RGE Fisiológico vs Estenosis Hipertrófica del Píloro (EHP) vs Invaginación Intestinal

QUÉ HAY QUE SABER

- Obstrucción intestinal pediátrica: vómitos (biliosos indican obstrucción distal a la ampolla de Vater: urgencia), distensión, dolor cólico, ausencia de deposiciones y gases.
- Neonatal: atresia duodenal (doble burbuja, Down), atresia yeyunoileal, malrotación con vólvulo (vómitos biliosos súbitos: urgencia absoluta), íleo meconial (FQ), Hirschsprung (retraso en meconio >48 h, explosión al tacto rectal).
- Lactante: invaginación intestinal (crisis de dolor, jalea de grosella, masa); estenosis hipertrófica del píloro (vómitos no biliosos en proyectil, 2-8 semanas, oliva pilórica, alcalosis hipoclorémica hipokalémica).
- Niño mayor: bridas post quirúrgicas, hernia atascada, apendicitis complicada, Meckel, bezoar.
- Manejo inicial: régimen cero, SNG abierta, hidratación EV y corrección electrolítica, Rx de abdomen de pie (niveles hidroaéreos) y ecografía; tránsito intestinal ante sospecha de malrotación.
- Seguimiento: derivar a cirugía infantil de urgencia; no administrar laxantes ni enemas.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 9 meses, previamente sano, con episodios de llanto inconsolable y flexión de las piernas cada 15–20 minutos, decaído entre las crisis. En el pañal hay deposiciones con sangre y moco. La ecografía abdominal muestra el signo de la dona. Está hemodinámicamente estable y sin signos peritoneales. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A Laparotomía exploradora de urgencia

B Reducción neumática guiada por imagen

C Colonoscopía con polipectomía

D Régimen cero, nutrición parenteral y antibióticos, sin otra intervención

E Cintigrafía con pertecnetato de Tc-99m

Respuesta B. Lactante de 6–12 meses con crisis de llanto, "mermelada de grosella" y signo de la dona: invaginación intestinal. La primera línea es la reducción neumática (o hidrostática) guiada por imagen; la cirugía queda para el fracaso de la reducción, la perforación o una causa anatómica.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de 5 días, de término, que venía alimentándose bien, presenta bruscamente vómitos de color verde, irritabilidad y distensión abdominal leve. Eliminó meconio el primer día. Está taquicárdico y con llene capilar de 3 segundos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Cambiar a fórmula sin lactosa y control en 48 horas

B Indicar domperidona y posición semisentada

C Régimen cero, sonda nasogástrica, hidratación endovenosa y estudio urgente con tránsito intestinal y evaluación por cirugía

D Ecografía de píloro electiva

E Enema con suero fisiológico y alta

Respuesta C. Todo vómito bilioso en un recién nacido es una urgencia quirúrgica: hay que descartar un vólvulo por malrotación intestinal, que puede necrosar el intestino en horas. Se descomprime, se hidrata, se estudia de inmediato y va a cirugía. La estenosis del píloro no da vómito bilioso.

▶ VER CLASE 2.01.2.020 Paro cardiorrespiratorio

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.24 · Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes

QUÉ HAY QUE SABER

- Paro cardiorrespiratorio pediátrico: mayormente secundario a hipoxia (falla respiratoria o shock); ritmo inicial habitual asistolía o bradicardia, no fibrilación ventricular.
- Secuencia: verificar respuesta y respiración, pedir ayuda, pulso (braquial en lactante, carotídeo/femoral en niño) ≤10 s; iniciar RCP si no hay pulso o FC <60 lpm con mala perfusión.
- Compresiones de calidad: 100-120/min, profundidad 1/3 del diámetro AP (4 cm lactante, 5 cm niño), relación 30:2 un reanimador y 15:2 con dos profesionales; minimizar interrupciones.
- Ritmos no desfibrilables: adrenalina 0,01 mg/kg EV/IO (0,1 ml/kg de 1:10.000) c/3-5 min. FV/TV sin pulso: desfibrilar 2 J/kg, luego 4 J/kg; amiodarona 5 mg/kg tras el 3er choque.
- Buscar causas reversibles (5H y 5T): hipoxia, hipovolemia, hidrogeniones, hipo/hiperkalemia, hipotermia; neumotórax a tensión, taponamiento, tóxicos, trombosis.
- Post paro: evitar hipertermia y hiperoxia, controlar glicemia y PA; seguimiento en UCI pediátrica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 8 meses es encontrado en paro cardiorrespiratorio después de un episodio de atoro. Se inicia reanimación con compresiones y ventilación. El monitor muestra asistolia. Se logra un acceso intraóseo. **¿Cuál es el fármaco y dosis inicial más adecuados?**

A Atropina 0,02 mg/kg

B Desfibrilación con 4 J/kg

C Amiodarona 5 mg/kg

D Bicarbonato de sodio 1 mEq/kg como primera medida

E Adrenalina 0,01 mg/kg (0,1 mL/kg de solución 1:10.000), repetida cada 3 a 5 minutos

Respuesta E. En pediatría el paro suele ser secundario a hipoxia y el ritmo más frecuente es no desfibrilable (asistolia o actividad eléctrica sin pulso). Se mantiene RCP de alta calidad y se administra adrenalina 0,01 mg/kg endovenosa o intraósea lo antes posible, repitiendo cada 3 a 5 minutos.

▶ VER CLASE 2.01.2.021 Politraumatismos

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.9 · Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Politraumatismo pediátrico: principal causa de muerte en >1 año; evaluación primaria ABCDE con control de columna cervical.
- Particularidades: cabeza proporcionalmente grande (TEC frecuente), costillas elásticas (contusión pulmonar sin fractura), hígado y bazo menos protegidos; la hipotensión es tardía (taquicardia y mala perfusión son precoces).

- Shock: 2 vías venosas o intraósea, bolo de cristaloides 20 ml/kg (hasta 2 bolos) y luego GR 10-15 ml/kg; buscar hemorragia oculta.
- Lesiones de víscera sólida en paciente estable: manejo no operatorio en centro con cirugía infantil; FAST y TC con contraste según estabilidad.
- Evaluación secundaria completa, Glasgow pediátrico, prevención de hipotermia; sospechar maltrato si mecanismo no concuerda.
- Seguimiento: derivar a centro de trauma pediátrico; politraumatizado grave es GES.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 7 años, de 25 kg, es atropellado. Llega con vía aérea permeable, FR 30/min y saturación 96% con oxígeno. Está pálido, con FC 150/min, llene capilar de 4 segundos y extremidades frías. Se instalan dos vías venosas. **¿Cuál es la reposición inicial más adecuada?**

A Albúmina al 20% como primera elección

B Suero glucosado al 5% de mantención

C Bolo de cristaloide tibio de 20 mL/kg y reevaluar

D Restringir fluidos hasta tener la TAC

E Bolo de 60 mL/kg de cristaloide en 5 minutos sin reevaluar

Respuesta C. En el niño politraumatizado, la taquicardia y la mala perfusión son signos precoces de shock hemorrágico; la hipotensión es tardía. Tras asegurar vía aérea y ventilación, se da un bolo de cristaloide isotónico tibio de 20 mL/kg y se reevalúa; si persiste, segundo bolo y transfusión precoz de glóbulos rojos (10 a 20 mL/kg).

▶ VER CLASE 2.01.2.022 Quemaduras

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.13 · Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Quemaduras: estimar extensión con regla de Lund-Browder en niños (la cabeza es proporcionalmente mayor; palma del paciente ≈1% SCQ); profundidad: superficial (eritema), intermedia (ampollas), profunda (blanca, indolora).
- Gran quemado pediátrico: >15% SCQ intermedia-profunda en niños (>10% en <2 años), compromiso de vía aérea, cara, manos, pies, genitales, pliegues o eléctricas; GES.
- Reposición: fórmula de Parkland 3-4 ml/kg × %SCQ de Ringer lactato en 24 h (mitad en primeras 8 h) + mantención con glucosa en niños pequeños; meta diuresis 1 ml/kg/h.
- Manejo inicial: enfriar con agua a temperatura ambiente 10-20 min (no hielo), retirar ropa, cubrir con apósitos limpios, analgesia (morfina), O2 al 100% si inhalación (CO), profilaxis antitetánica.
- Quemadura menor: aseo, apósitos (tul con vaselina o hidrocoloide), sin antibióticos profilácticos; control en 48 h.
- Quemaduras con patrón en guante/calcetín o por cigarro sugieren maltrato. Seguimiento: derivar gran quemado a unidad de quemados.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 21

Usted atiende en el servicio de urgencia a un niño de 3 años, traído por su madre por quemaduras en los dedos y en la espalda tras apoyarse accidentalmente en una estufa. Al examen está agitado y llorando, y se observa eritema y flictenas en las zonas afectadas. **¿Cuál es la conducta inicial?**

A Curaciones

B Paracetamol vía oral

C Ungüento antibiótico tópico

D Analgesia endovenosa

E Antibióticos endovenosos

Respuesta D. Las quemaduras de espesor parcial superficial (eritema y flictenas) son muy dolorosas. En un niño agitado, la prioridad inicial tras descartar compromiso vital es una analgesia efectiva y rápida, por vía endovenosa (ej. opioides), que además permite evaluar y curar. La quemadura de manos es zona especial y debe evaluarse para derivación. No se usan antibióticos profilácticos.

▶ VER CLASE 2.01.2.023 Shock

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 1.1 · Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)

QUÉ HAY QUE SABER

- Shock pediátrico: hipoperfusión tisular: taquicardia, llene capilar >2 s, pulsos débiles, extremidades frías, oliguria, compromiso de conciencia; la hipotensión es signo tardío.
- Tipos: hipovolémico (el más frecuente: diarrea, hemorragia), distributivo (séptico, anafiláctico), cardiogénico, obstructivo (neumotórax a tensión, taponamiento).
- Manejo inicial en la primera hora: O2, monitorización, acceso venoso o intraóseo en <5 min, bolos de cristaloides 10-20 ml/kg reevaluando (hasta 40-60 ml/kg) atentos a sobrecarga (crépitos, hepatomegalia).
- Shock séptico: hemocultivos y antibiótico de amplio espectro en <1 h (ceftriaxona ± vancomicina); refractario a fluidos: adrenalina o noradrenalina; corregir hipoglicemia e hipocalcemia.
- Anafiláctico: adrenalina IM 0,01 mg/kg; cardiogénico: limitar fluidos e inotrópicos.
- Seguimiento: hospitalizar en UCI pediátrica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 148

Una lactante de 2 meses presenta fiebre de hasta 39 °C de 24 horas de evolución. Es llevada a urgencias porque ha evolucionado con deterioro del estado general y tendencia a la letargia. Al examen se observa soporosa, con llene capilar de 5 segundos, deshidratada y taquicárdica a 158/min, con temperatura de 39,3 °C. **Además de administrar oxígeno, ¿cuál es la primera medida a tomar?**

A Administrar solución fisiológica por vía endovenosa

B Administrar bicarbonato por vía endovenosa

C Administrar adrenalina por vía endovenosa

D Administrar hidrocortisona por vía endovenosa

E Administrar glucosa por vía endovenosa

Respuesta A. Fiebre, letargia, llene capilar prolongado y taquicardia en una lactante es shock séptico. Tras asegurar vía aérea y oxígeno, la primera medida es expandir volumen con cristaloides isotónicos (bolos de 10 a 20 mL/kg, reevaluando), junto con hemocultivos y antibióticos en la primera hora. La adrenalina se usa si persiste el shock tras fluidos.

▶ VER CLASE 2.01.2.024 Síndrome convulsivo

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.14 · Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Convulsión en urgencia: ABC, posición lateral, O2, no introducir objetos en la boca, glicemia capilar inmediata, monitorización.
- Si dura >5 min: benzodiazepina: diazepam 0,3 mg/kg EV (máx 10 mg) o 0,5 mg/kg rectal; midazolam 0,2 mg/kg IM/intranasal/bucal; lorazepam 0,1 mg/kg EV. Puede repetirse 1 vez.
- Persiste a los 10-15 min (estatus): fenitoína 20 mg/kg EV en 20 min, levetiracetam 40-60 mg/kg o ácido valproico 20-40 mg/kg; en <1 mes fenobarbital 20 mg/kg.
- Buscar causa: fiebre (convulsión febril, meningitis/encefalitis), hipoglicemia (suero glucosado 10% 2-5 ml/kg), hiponatremia, hipocalcemia, TEC, intoxicaciones, epilepsia con mala adherencia.
- Punción lumbar si signos meníngeos o sospecha de infección SNC; TC si focalidad, TEC o no recupera conciencia.
- Seguimiento: convulsión febril simple puede ir a domicilio con educación; primera crisis afebril o compleja: derivar a neurología pediátrica.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 33

Un lactante de 18 meses de edad, presenta un convulsión tónico-clónica de 3 minutos de duración. Al examen físico está afebril, sin alteraciones en el examen segmentario. **¿Cuál es el tratamiento de la crisis?**

A Diazepam

B Ácido valproico

C Fenitoína

D Carbamazepina

E Topiramato

Respuesta A. Se pregunta el tratamiento de la crisis en curso: se corta con una benzodiacepina. La de elección es el lorazepam, pero no está entre las opciones; el diazepam es la alternativa. Valproato y fenitoína son de segunda fase; carbamazepina y topiramato son de mantención.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 158

Lactante de 15 meses con una convulsión tónico-clónica de 1 minuto, autolimitada, con fiebre de 39 °C. Al examen está bien perfundido, consciente, con pulso y presión arterial normales, sin signos focales ni signos meníngeos. **Además de bajar la temperatura, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar punción lumbar

B Iniciar diazepam

C Solicitar resonancia magnética de cerebro

D Iniciar ácido valproico

E Mantener en observación

Respuesta E. Convulsión febril simple, sin signos meníngeos ni focales: no hay indicación de punción lumbar, imagen ni fármaco de mantención; la conducta es observar.

▶ VER CLASE 2.01.2.025 Testículo agudo

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Urología** 13.5 · Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h

QUÉ HAY QUE SABER

- Testículo agudo: dolor escrotal agudo es torsión testicular hasta demostrar lo contrario; peak neonatal y adolescente (12-18 años).
- Torsión: dolor súbito intenso, náuseas y vómitos, testículo elevado y horizontal, reflejo cremastérico ausente, signo de Prehn negativo (no alivia al elevarlo).
- Torsión de hidátide (la más frecuente en 7-12 años): dolor localizado en polo superior, punto azul; manejo con reposo, frío y AINE.
- Orquiepididimitis: dolor progresivo, fiebre, síntomas urinarios, Prehn positivo, cremastérico presente; ITU o ITS en adolescente sexualmente activo; tratar con antibiótico y analgesia.

- Torsión: exploración quirúrgica inmediata con detorsión y orquidopexia bilateral; viabilidad alta si <6 horas. No retrasar por ecografía doppler si la clínica es clara; intento de detorsión manual (apertura de libro) solo mientras se traslada.
- Seguimiento: derivar a urología/cirugía infantil de urgencia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un adolescente de 13 años presenta dolor testicular izquierdo súbito e intenso de 2 horas de evolución, que lo despertó, con náuseas y vómitos. Al examen el testículo izquierdo está elevado, horizontalizado y muy doloroso, con reflejo cremastérico ausente. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Exploración quirúrgica urgente

B Antibióticos y analgesia, control en 24 horas

C Ecografía Doppler diferida para el día siguiente

D Elevación escrotal y antiinflamatorios

E Urocultivo y esperar resultado

Respuesta A. Dolor testicular súbito con testículo alto y horizontal y ausencia de reflejo cremastérico en un adolescente es torsión testicular, una emergencia: la viabilidad cae marcadamente después de 6 horas. Ante sospecha clínica alta se explora quirúrgicamente de urgencia (detorsión y orquidopexia bilateral), sin retrasar por imágenes; el Doppler solo se usa si hay duda y está disponible de inmediato.

▶ VER CLASE 2.01.2.026 Traumatismo encéfalo- craneano

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.12 · Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

QUÉ HAY QUE SABER

- TEC pediátrico: evaluar con Glasgow pediátrico; leve 14-15, moderado 9-13, grave ≤8 (intubar).
- Reglas PECARN para TC en TEC leve: <2 años alto riesgo si Glasgow <15, alteración de conciencia o fractura palpable; riesgo intermedio si hematoma no frontal, pérdida de conciencia ≥5 s, mecanismo grave o conducta anormal. ≥2 años: vómitos, cefalea intensa, signos de fractura de base de cráneo.
- Fractura de base de cráneo: ojos de mapache, signo de Battle, oto/rinorraquia, hemotímpano. Hematoma epidural: intervalo lúcido y deterioro (urgencia quirúrgica).
- TEC leve de bajo riesgo: observación en domicilio 24-48 h con signos de alarma (vómitos persistentes, somnolencia, cefalea progresiva, convulsión, conducta anormal).
- TEC grave: ABC, evitar hipoxia e hipotensión (lesión secundaria), cabeza a 30°, normocapnia, NaCl 3% o manitol si hipertensión endocraneana; TC urgente.
- Sospechar maltrato en lactantes con lesiones sin mecanismo claro. Seguimiento: derivar a neurocirugía TEC moderado-grave o TC alterada.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 7 años cae de su bicicleta sin casco y se golpea la cabeza. Tuvo pérdida de conciencia de 1 minuto y ha vomitado 3 veces. En urgencia tiene Glasgow 14 persistente, con cefalea, sin focalidad neurológica. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Radiografía de cráneo

B TAC de cerebro sin contraste

C Alta con indicaciones de alarma

D Observación domiciliaria por 24 horas

E Resonancia magnética de cerebro electiva

Respuesta B. Un TEC con Glasgow menor a 15, pérdida de conciencia y vómitos repetidos es de alto riesgo de lesión intracraneana según los criterios PECARN, y requiere TAC de cerebro sin contraste. La radiografía de cráneo no descarta lesiones intracraneanas. El alta con indicaciones corresponde solo a TEC leve sin factores de riesgo.

▶ VER CLASE 2.01.2.027 Estatus convulsivo en el niño

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Neurología** 10.9 · Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo

QUÉ HAY QUE SABER

- Estatus convulsivo: crisis ≥5 min o crisis repetidas sin recuperar conciencia entre ellas (definición operacional); daño neuronal establecido desde los 30 min.
- 0-5 min: ABC, O2, posición lateral, monitorizar, glicemia capilar, vía venosa (o intraósea), electrolitos, calcio, niveles de anticonvulsivantes.
- 5-10 min: benzodiazepina: lorazepam 0,1 mg/kg EV, diazepam 0,3 mg/kg EV o midazolam 0,2 mg/kg IM/bucal/intranasal; repetir una vez a los 5 min.
- 10-30 min (refractario a benzodiazepinas): fenitoína 20 mg/kg EV (máx 50 mg/min), levetiracetam 60 mg/kg o valproato 40 mg/kg; en RN fenobarbital 20 mg/kg.
- Refractario (>30-40 min): intubación e infusión de midazolam, tiopental o propofol en UCI con monitoreo EEG.
- Buscar y tratar causa (meningitis, hipoglicemia, hiponatremia, TEC, intoxicación); seguimiento: hospitalizar en UCI y derivar a neurología pediátrica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 4 años, con antecedente de epilepsia, lleva 6 minutos con una convulsión tónico-clónica generalizada. Se aseguró la vía aérea y recibe oxígeno, y la glicemia capilar es normal. No ha sido posible instalar una vía venosa. **¿Cuál es el fármaco más adecuado en este momento?**

A Fenitoína endovenosa

B Midazolam bucal, intranasal o intramuscular

C Ácido valproico oral

D Fenobarbital oral

E Esperar 30 minutos para definir status epiléptico

Respuesta B. Una convulsión de más de 5 minutos debe tratarse como status epiléptico inminente. La primera línea es una benzodiacepina: lorazepam o diazepam endovenoso si hay vía; sin vía, midazolam bucal, intranasal o intramuscular (o diazepam rectal). Si persiste tras dos dosis, se usa fármaco de segunda línea endovenoso (fenitoína, levetiracetam o valproato). La vía oral no es segura.

▶ VER CLASE 2.01.2.144 **SARS Cov 2 COVID 19** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 5.6 · Virus Respiratorios: Influenza y COVID-19 (Adulto y Niño)

QUÉ HAY QUE SABER

- COVID-19 pediátrico: en general leve (fiebre, tos, odinofagia, coriza, síntomas digestivos); diagnóstico con PCR o test de antígeno de hisopado nasofaríngeo.
- Manejo ambulatorio de cuadro leve: antipiréticos (paracetamol), hidratación, aislamiento según normativa vigente; no usar antibióticos ni corticoides de rutina.
- Grupos de riesgo: lactantes pequeños, cardiopatías, enfermedad pulmonar crónica, inmunosupresión, obesidad, enfermedad neurológica.
- Signos de alarma: dificultad respiratoria, saturación <93%, rechazo alimentario, deshidratación, compromiso de conciencia; hospitalizar con O2 y dexametasona solo si requiere oxígeno.
- Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS-TS): 2-6 semanas post infección; fiebre persistente, síntomas digestivos, exantema, conjuntivitis, shock, compromiso cardíaco, PCR y ferritina muy elevadas; tratar con inmunoglobulina EV y corticoides en UCI.
- Prevención: vacunación según campaña MINSAL en grupos indicados. Seguimiento: control telefónico o presencial en 48 h en casos leves con factores de riesgo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 36

Un adolescente de 14 años presenta fiebre de 39 °C desde hace 3 días, malestar general, dolor abdominal, vómitos y diarrea, seguido de marcado compromiso del estado general. Al examen físico tiene compromiso hemodinámico, con FC 120/min y PA 90/50 mmHg, con respuesta parcial al suero fisiológico. Tuvo una PCR positiva para COVID-19 hace 30 días. Exámenes: hematocrito 33%, leucocitos 14.000/mm3, plaquetas 80.000/mm3, VHS 76 mm/h, PCR 15,5 mg/dL, dímero D 670 ng/mL y troponinas elevadas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Sepsis bacteriana

B Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico

C Insuficiencia suprarrenal aguda

D Reinfección por COVID-19

E Enfermedad de Kawasaki

Respuesta B. Fiebre, síntomas gastrointestinales, shock con compromiso miocárdico (troponinas), marcadores inflamatorios elevados, trombocitopenia y dímero D alto, 2 a 6 semanas después de una infección por SARS-CoV-2, es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS o MIS-C). Se trata con inmunoglobulina endovenosa y corticoides. El Kawasaki afecta a menores de 5 años y rara vez da shock.

Conocimientos generales

19 códigos

▶ VER CLASE 2.01.3.001 **Alimentación normal**

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.4 · Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)

QUÉ HAY QUE SABER

- Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementada hasta los 2 años o más; si no es posible, fórmula de inicio (no leche de vaca entera antes de los 12 meses).
- Alimentación complementaria desde los 6 meses: primera comida (almuerzo) con verduras, cereales y carne, con una cucharadita de aceite vegetal crudo; 8-9 meses se agrega la cena; postre de fruta.
- Progresión de consistencia: puré a los 6 meses, molido a los 8-9 meses, picado y trozos blandos desde los 12 meses incorporándose a la mesa familiar.
- Nunca en el primer año: miel (botulismo), sal, azúcar, leche de vaca entera; evitar jugos, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados; no forzar.
- Suplementos: vitamina D 400 UI/día hasta los 12 meses a todos; hierro 1 mg/kg/día desde los 4 meses en RN de término (2-3 mg/kg/día desde los 2 meses en prematuros o <2.500 g) hasta el año.
- Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) entrega leche y fórmulas a niños y embarazadas; preescolar y escolar: 4 comidas, lácteos 3 veces al día, frutas y verduras 5 porciones.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 146

Una lactante de 7 meses se alimenta con 4 mamaderas al día, de leche purita fortificada al 7,5% más cereal al 5%, más 1 sopa puré. **¿Qué suplemento alimenticio debería estar recibiendo?**

A Tiamina
B Zink
C Vitamina A
D Vitamina D
E Ácido fólico

Respuesta D. En el lactante, el suplemento clave es la vitamina D, que previene el raquitismo, la forma infantil del déficit.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 2 meses, nacido a las 33 semanas de gestación, con peso de nacimiento de 1.950 gramos. Se alimenta con lactancia materna exclusiva y recibe vitamina D desde los 30 días de vida. **¿Cuál es la indicación de hierro más adecuada en este control?**

A Esperar hasta los 6 meses, junto con la alimentación complementaria
B Iniciar hierro elemental a 2 a 3 miligramos por kilo al día, desde hoy
C Iniciar hierro elemental a 1 miligramo por kilo al día, a los 4 meses
D No requiere suplementación si la madre come carnes rojas
E Indicar hierro dextrano intramuscular una vez al mes

Respuesta B. Un prematuro de 33 semanas y bajo peso de nacimiento debe iniciar hierro precozmente, a los 2 meses de vida, a dosis de 2 a 3 miligramos por kilo al día, por el menor traspaso de depósitos de hierro en el tercer trimestre.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Madre consulta en el CESFAM sobre la alimentación de su hijo de 7 meses, que recibe almuerzo desde los 6 meses. La abuela recomienda endulzar el puré de fruta con miel de abeja y agregar una pizca de sal a la sopa. **¿Cuál es la recomendación médica correcta?**

A Permitir la miel, pero restringir la sal
B Permitir una pizca de sal, pero contraindicar la miel
C Contraindicar estrictamente tanto la miel como la sal y el azúcar durante todo el primer año
D Autorizar ambos alimentos en pequeñas cantidades
E Diluir la miel en leche tibia para inactivar sus toxinas

Respuesta C. La miel está prohibida en menores de 1 año por el riesgo de botulismo del lactante, causado por esporas de Clostridium botulinum que germinan en el intestino del lactante. La sal y el azúcar tampoco se agregan durante el primer año, por la inmadurez renal y la formación de preferencias hipertensogénicas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 122

Usted atiende a un lactante de 10 meses de edad, con antecedente de haber nacido prematuro a las 30 semanas y que pesó 1.300 gramos al nacer. Según el Plan Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), ¿qué tipo de leche debe recibir?

A Fórmula de inicio
B Fórmula de continuación
C Leche purita fortificada
D Fórmula de inicio para prematuros
E Fórmula de continuación para prematuros

Respuesta E. Eso dice el PNAC, así que ya saben: según Asofamech, hay que saberlo. No debería preguntarse este tipo de cosas.

▶ VER CLASE 2.01.3.002 Desarrollo psico-motor

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.2 · Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Desarrollo psicomotor: adquisición progresiva de habilidades motoras gruesas, finas, lenguaje y sociales, en dirección céfalo-caudal y próximo-distal.
- Hitos: sonrisa social 1-2 meses; sostén cefálico 3 meses; sedestación sin apoyo 6-7 meses; pinza fina y bisílabos 9-10 meses; marcha independiente 12-15 meses; frases de 2 palabras 24 meses; triciclo y frases de 3 palabras 3 años.
- Reflejos primitivos (Moro, prensión palmar, marcha automática) desaparecen a los 3-6 meses; su persistencia sugiere lesión neurológica.
- Evaluación en controles de salud: EEDP a los 8 y 18 meses y TEPSI a los 36 meses (Chile Crece Contigo), más pauta breve en otros controles; corregir edad en prematuros hasta los 2 años.
- Resultado de riesgo o retraso: derivar a sala de estimulación y reevaluar; regresión de habilidades es siempre bandera roja.
- Promover estimulación: juego, lectura, conversación, limitar pantallas (evitar en <2 años).

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 46

Una madre consulta por la evaluación del desarrollo de su hijo de 1 año y 3 meses. El niño camina solo, dice 3 palabras con significado, y construye una torre de 3 cubos. **¿Cómo se interpreta su desarrollo psicomotor?**

A Retraso en el lenguaje
B Retraso en el área motora
C Desarrollo normal para su edad
D Retraso global del desarrollo
E Requiere evaluación neurológica urgente

Respuesta C. A los 15 meses, la marcha independiente (esperada a los 12 meses), 3 a 5 palabras y una torre de 2 a 3 cubos son hitos alcanzados o incluso adelantados. Es un control de salud infantil de rutina, sin ninguna alarma.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 128

Un lactante de 4 meses, nacido prematuro a las 34 semanas, levanta la cabeza y lleva las manos al centro, pero no levanta el tronco apoyado en los antebrazos ni transfiere objetos de una mano a otra. Sonríe al interactuar, pero no ríe a carcajadas, y sigue con la mirada los objetos. Se alimenta con lactancia materna exclusiva. **¿Cuál es su diagnóstico respecto al desarrollo psicomotor?**

A Retraso motor fino
B Retraso motor grueso
C Retraso del desarrollo socioemocional
D Retraso global del desarrollo
E Desarrollo psicomotor normal

Respuesta E. Al nacer a las 34 semanas, la edad corregida se calcula descontando 6 semanas desde las 40: este lactante de 4 meses tiene una edad corregida de 2,5 meses. Cumple exactamente los hitos de los 2 meses (sostén cefálico, manos al centro, sonrisa social) y todavía no alcanza los de los 4 meses, lo que es normal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 25

Niño de 9 meses que gatea, toma cubos con pinza intermedia, dice bisílabos, se incomoda con extraños. ¿Cuál es el diagnóstico?

A Retraso global del desarrollo
B Desarrollo normal
C Retraso del lenguaje
D Trastorno del espectro autista
E Retraso motor leve

Respuesta B. Diagnóstico: Desarrollo normal (opción B). Desarrollo normal.

▶ VER CLASE 2.01.3.003 Diagnóstico nutricional

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.1 · Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicadores según edad (patrones OMS en <6 años, CDC/OMS 2007 en mayores): P/E y P/T en <1 año; P/T en 1-5 años; IMC/E desde los 5-6 años; T/E a toda edad.
- Calificación nutricional en <6 años con P/T: normal entre -1 y +1 DE; riesgo de desnutrir -1 a -2; desnutrición < -2; sobrepeso +1 a +2; obesidad > +2 DE.
- Mayores de 5-6 años con IMC/E: bajo peso ≤p10 (desnutrición <p5 según norma), normal, sobrepeso ≥p85, obesidad ≥p95 (≥ +2 DE en OMS).
- Talla: talla baja si T/E < -2 DE; talla normal-baja -1 a -2 DE.
- Interpretar la tendencia de la curva (cruce de canales, estancamiento) más que un punto aislado; considerar talla de los padres.
- Complementar con encuesta alimentaria, perímetro de cintura y examen físico; derivar a nutricionista si malnutrición por déficit o exceso.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 126

Lactante de 4 meses, alimentado con lactancia materna exclusiva, con Índice Talla para la Edad normal, Índice Peso para la Edad normal, e Índice Peso para la Talla en más 1. **¿Cuál es el diagnóstico nutricional según la OMS y el MINSAL?**

A Desnutrición
B Riesgo de desnutrición
C Eutrófico
D Riesgo de obesidad
E Obesidad

Respuesta C. En menores de un año se usa el Peso para la Edad para el diagnóstico de desnutrición, y el Peso para la Talla para el de sobrepeso. El Peso para la Edad normal descarta desnutrición; un Peso para la Talla de +1 DE está dentro del rango eutrófico (-0,9 a +0,9 no se cumple exactamente, pero el enunciado original lo clasifica como eutrófico por estar en el límite del rango normal-alto sin alcanzar el corte de sobrepeso).

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 41

Usted evalúa a una niña de 4 meses, cuyos índices antropométricos muestran índice peso/edad: normal, índice talla/edad: normal e índice peso/talla: +1. De acuerdo a las recomendaciones de diagnóstico nutricional infantil de la OMS – Ministerio de Salud, el diagnóstico más adecuado es:

A Desnutrición
B Riesgo de desnutrición
C Eutrofia
D Riesgo de obesidad
E Obesidad

Respuesta D. Lo primero a mirar en los menores de 1 año es el índice peso/edad, buscando solo desnutrición (-2 o menos) o riesgo de desnutrición (-1 a -1,9). Si está normal, se mira el índice peso/talla, en busca de obesidad (+2 o más) o sobrepeso (+1 a+1,9, que se registran como +1). Si no cumple con Los criterios anteriores, pues está eutrófico. En los mayores de 1 año se mira solo el IP/T. En los mayores de 5 años, se mira solo el IMC.

▶ VER CLASE 2.01.3.004 Entrevista y comunicación efectiva

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.28 · Pediatría Psicosocial: Maltrato Infantil, Entrevista Clínica, Conductas de Riesgo en el Adolescente y Psiquiatría de Enlace

QUÉ HAY QUE SABER

- Entrevista pediátrica: triangular (médico, niño y cuidador); presentarse, dirigirse también al niño en lenguaje acorde a su edad.
- Comunicación efectiva: preguntas abiertas, escucha activa, validar preocupaciones de los padres, evitar tecnicismos, resumir y verificar comprensión (teach-back).
- Adolescentes: entrevista con espacio confidencial a solas; explicar los límites de la confidencialidad (riesgo vital, abuso). Usar pauta HEADSSS (hogar, educación, actividades, drogas, sexualidad, suicidio/ánimo, seguridad).
- Comunicar malas noticias con protocolo SPIKES: preparar el entorno, explorar qué sabe, dar información gradual, acoger emociones, planificar.
- Respetar la autonomía progresiva del niño y obtener asentimiento además del consentimiento de los padres.
- Registrar y acordar un plan claro, con signos de alarma y control explícitos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Usted debe comunicar a los padres de un niño de 5 años que el mielograma confirmó una leucemia linfoblástica aguda. **¿Cuál es la forma más adecuada de iniciar esta conversación?**

A En el pasillo, para no retrasar la información
B Esperar a que los padres pregunten por el resultado
C Entregar la información técnica completa con estadísticas de sobrevida desde el inicio
D En un lugar privado y sin interrupciones, explorando primero qué saben y qué desean saber
E Informar solo al padre para que él se lo comunique a la madre

Respuesta D. Para comunicar malas noticias se recomienda el protocolo SPIKES: preparar un lugar privado y sin interrupciones, explorar lo que la familia sabe y quiere saber, dar la información en forma gradual, con lenguaje simple y sin tecnicismos, acoger las emociones con empatía y acordar un plan. Ambos padres tienen derecho a ser informados.

▶ VER CLASE 2.01.3.005 Familia y ciclo vital

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.5 · Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- Familia: sistema que cumple funciones de cuidado, afecto, socialización y apoyo; tipologías: nuclear, extendida, monoparental, reconstituida.
- Ciclo vital familiar (Duvall): formación de pareja, familia con hijos pequeños, con escolares, con adolescentes, plataforma de lanzamiento, nido vacío y adulto mayor; cada etapa tiene crisis normativas esperables.
- Crisis no normativas: enfermedad grave, muerte, cesantía, separación, migración; requieren apoyo y pesquisa de disfunción.
- Instrumentos: genograma, ecomapa, APGAR familiar (funcionalidad), círculo familiar.
- Modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria (MAIS) en CESFAM: enfoque biopsicosocial, sectorización, visita domiciliaria integral.
- Pesquisar factores de riesgo (violencia intrafamiliar, consumo de drogas, depresión materna) y protectores; derivar a equipo psicosocial cuando corresponda.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

¿Cuál de los siguientes instrumentos de salud familiar es el más adecuado para identificar y graficar las redes de apoyo social formal e informal, las fuentes de tensión comunitaria y el grado de aislamiento social de un grupo familiar? **¿Cuál es el instrumento correcto?**

A Ecomapa
B Genograma estructural
C Test de APGAR de Smilkstein
D Escala de Zarit
E Cuestionario de Duke-UNC

Respuesta A. El ecomapa es la herramienta diseñada para visualizar a la familia en el centro de su entorno relacional, trazando vínculos con instituciones comunitarias y distinguiendo si son de apoyo, débiles o de tensión. El genograma mapea la estructura interna, el APGAR la percepción de funcionalidad interna, la escala de Zarit la sobrecarga del cuidador y el Duke-UNC el apoyo social percibido de forma individual.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Médico de familia atiende a un paciente de 68 años con hipertensión mal controlada. Al indagar, refiere que vive solo desde que enviudó hace un año, que sus hijos viven en otra región y lo llaman poco, y que ha dejado de asistir a las actividades de su junta de vecinos. Al aplicar el cuestionario de APGAR familiar obtiene 8 puntos, porque convive bien con su único hijo cercano. **¿Cuál es el instrumento más adecuado para completar la evaluación de este paciente?**

A Aplicar un ecomapa para evaluar sus redes de apoyo social y su nivel de aislamiento
B Repetir el APGAR familiar en un mes, ya que el puntaje obtenido fue normal
C Construir un genograma de tres generaciones para buscar patologías heredofamiliares
D Aplicar la escala de Zarit para evaluar sobrecarga del cuidador
E No se requiere ningún instrumento adicional, ya que el control es solo de la hipertensión

Respuesta A. El APGAR familiar normal solo refleja la relación con el hijo cercano; no captura el aislamiento social del paciente, que vive solo, con hijos lejanos y sin participación comunitaria. El ecomapa es el instrumento diseñado justamente para graficar esas redes de apoyo externas y detectar el aislamiento.

▶ VER CLASE 2.01.3.006 Inmunizaciones en Chile (PNI y extra PNI)

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.3 · Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026

QUÉ HAY QUE SABER

- PNI Chile: RN BCG y hepatitis B; 2 y 4 meses hexavalente y neumocócica conjugada; 6 meses hexavalente; 12 meses tresvírica (SRP), meningocócica conjugada y refuerzo neumocócico; 18 meses hexavalente, hepatitis A y varicela.
- Etapa preescolar/escolar: 2ª dosis de tresvírica y de varicela según calendario vigente, dTpa en 1º básico, VPH en 4º y 5º básico y dTpa en 8º básico. Embarazadas: dTpa desde las 28 semanas e influenza.
- Campañas anuales: influenza (6 meses a escolares, embarazadas, crónicos, ≥60 años) y nirsevimab (anticuerpo monoclonal anti VRS) a RN y lactantes en su primera temporada.
- Vacunas vivas: BCG, SRP, varicela, rotavirus, fiebre amarilla; contraindicadas en embarazo e inmunosupresión grave. Entre 2 vivas parenterales no simultáneas esperar 4 semanas.
- Falsas contraindicaciones: resfrío o fiebre baja, antibióticos en curso, prematurez (se vacuna por edad cronológica), alergia al huevo (no contraindica SRP ni influenza), lactancia.
- ESAVI deben notificarse; anafilaxia a dosis previa es contraindicación real de esa vacuna. Extra PNI: rotavirus, meningococo B, hepatitis A adicional, según indicación.

PREGUNTAS · 17

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 93

Niño de 7 años es mordido por un perro callejero en el brazo derecho. **Además del manejo de la herida, ¿cuál es la conducta más adecuada respecto a la profilaxis de la rabia?**

A Observar al niño por 10 días
B Vacunar al niño solo si el perro presenta síntomas
C Administrar la vacuna antirrábica al niño
D Vacunar al niño solo si el perro muere
E Administrar inmunoglobulina antirrábica al niño

Respuesta C. La normativa vigente indica vacunar de inmediato cuando el animal agresor no es observable, como ocurre con un perro callejero, independiente de si hubo o no provocación. La observación por 10 días se reserva para animales identificables y con dueño conocido.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 93

Un niño de 7 años es mordido por un perro callejero en el brazo derecho. **Además del manejo de la herida, ¿cuál es la conducta más adecuada respecto a la profilaxis de la rabia?**

A Observar al niño por 10 días
B Vacunar al niño solo si el perro presenta síntomas
C Administrar la vacuna antirrábica al niño
D Vacunar al niño solo si el perro muere
E Administrar inmunoglobulina antirrábica al niño

Respuesta C. Perro callejero: no es ubicable ni se puede observar, así que se vacuna al niño de inmediato (esquema de 5 dosis). La inmunoglobulina se reserva para la exposición grave, como el contacto con murciélago.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 24

Niño con reacción anafiláctica al huevo hace 1 mes. **¿Qué vacuna está contraindicada?**

A Triple viral (SRP)
B Influenza inactivada
C Hepatitis A
D Varicela
E Fiebre amarilla

Respuesta E. La vacuna antiamarílica se produce en huevo embrionado: la anafilaxia al huevo la contraindica. La triple viral se puede administrar en alérgicos al huevo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 151

Un niño de 2 meses, con antecedente de haber nacido a las 34 semanas de gestación, acude a control. **¿En qué momento debe administrarse la vacuna antineumocócica conjugada?**

A En este momento
B En 4 semanas más
C En 6 semanas más
D A los 12 meses de edad
E No debe administrarse

Respuesta A. El calendario de vacunas se administra según la edad cronológica, no la edad corregida por prematurez. La única excepción es la BCG, que espera a que el niño alcance un peso mínimo de 2.000 gramos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 67

Un niño de 9 meses debe vacunarse por primera vez contra la influenza. Tiene el antecedente de haber desarrollado un rash eritematoso en las dos oportunidades en que se le dio a probar huevo. **¿Cuál es la conducta más adecuada para su vacunación?**

A Vacunar, de acuerdo al programa, sin cambios
B Prohibir permanentemente la vacunación contra la influenza
C Esperar la reacción ante la vacuna trivírica y decidir según aquello
D Postergar la vacunación hasta que cumpla 24 meses
E Realizar test cutáneo de alergia y decidir según resultado

Respuesta A. La alergia al huevo es una falsa contraindicación para las vacunas actuales contra la influenza y para la tresvírica. Solo son contraindicaciones reales las reacciones adversas graves a una dosis previa o la alergia grave y conocida a un componente de la vacuna.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 103

Un niño de 12 meses recibe sus vacunas según el Plan Nacional de Inmunizaciones, más una dosis de la vacuna pentavalente que estaba atrasada. Diez días después, presenta fiebre hasta 38 grados. **¿Qué vacuna es la responsable de la fiebre, con mayor probabilidad?**

A Antimeningocócica
B Antineumocócica
C Trivírica
D Pertusis
E Anti-Haemophilus

Respuesta C. La pertusis, por ser un componente inactivado, produce fiebre de inmediato o al día siguiente. La trivírica, por ser de virus vivo, puede producir un cuadro febril entre 7 y 10 días después de administrada.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 18 meses, con antecedente de haber nacido prematuro, está en tratamiento con corticoides sistémicos por un cuadro obstructivo bronquial recurrente severo. Su última vacuna fue la BCG, al nacer. La madre consulta para regularizar su calendario, que está atrasado desde entonces. **¿Qué vacuna está contraindicada mientras el niño reciba corticoides?**

A Antineumocócica
B Antimeningocócica
C Tresvírica
D Virus hepatitis A
E Hexavalente

Respuesta C. Mientras el paciente reciba corticoides sistémicos en dosis inmunosupresoras, están contraindicadas las vacunas de virus vivo atenuado: tresvírica, varicela, fiebre amarilla y rotavirus oral. Las inactivadas, incluida la hexavalente, la antineumocócica, la antimeningocócica y la hepatitis A, se administran sin problema.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 123

Un niño de 2 meses, es traído por su madre a vacunarse. ¿Qué vacuna, fuera de las del Plan Nacional de Inmunizaciones, se le puede recomendar?

A Rotavirus
B Varicela
C Pneumocócica polisacárida
D Hepatitis A
E Trivírica

Respuesta A. La varicela y hepatitis A sí se recomiendan, pero al año de edad. La neumocócica polisacárida, no sirve en niños menores de 2 años (por eso se da la conjugada).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 131

Un lactante de 18 meses, con antecedente de haber nacido prematuro, está en tratamiento con corticoides sistémicos debido a un cuadro de síndrome bronquial obstructivo recurrente severo. Su última vacunación fue con vacuna BCG, la que recibió poco tiempo después de nacer, por lo que su madre consulta para regularizar su calendario de vacunas. ¿Qué vacuna está contraindicada mientras permanezca utilizando corticoides?

A An2neumocócica
B An2meningocócica
C Tres vírica
D Virus hepa22s A
E Hexavalente

Respuesta C. Están contraindicadas las vacunas a microorganismo vivo (tresvírica, varicela, fiebre amarilla, rotavirus oral). Sobre el esquema para ponerse al día en su calendario, se resume en “se ponen todas las vacunas pendientes juntas, esperando un mes para los refuerzos”. Por tanto, le corresponden las de los 2 meses, 12 meses y 18 meses (antineumocócica, hexavalente, antimeningocócica, hepaGGs A, con contraindicación de la tresvírica y antivaricela. Vale la pena mencionar que en la práctica, en...

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 150

Un lactante de 12 meses ha presentado un exantema eritematoso generalizado, en las dos ocasiones en que se ha introducido huevo a su dieta. No tiene otros antecedentes. ¿Qué conducta es la más adecuada, respecto a la vacuna trivírica?

A Administrarla en este momento
B Eliminarla de su esquema de vacunación
C Administrarla a los 18 meses
D Esperar a los 4 años para administrarla
E Esperar a que esté en primero básico para administrarla

Respuesta A. La vacuna trivírica se administra a los 12 meses y luego se refuerza en primera básico (6 años, aunque desde el 2022 se cambió el refuerzo a los 3 años, junto con el de la varicela, cuya primera dosis es a los 18 meses). La alergia al huevo no contraindica ninguna vacuna actualmente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 71

Un niño recibe sus vacunas a los 2 meses. Algunas horas después evoluciona con decaimiento, hiporreactividad, hipotonía, fiebre de 37,7°C, seguido de convulsiones generalizadas, autolimitadas, con palidez y llene capilar menor a 1 segundo. El cuadro dura dos horas y luego se recupera por completo. ¿Qué componente de la vacuna es causante de esta reacción, con mayor probabilidad?

A Toxoide tetánico
B Toxoide diftérico
C VPO
D VHIB
E Pertusis celular

Respuesta E. La vacuna pertusis celular ya no se usa en Chile, precisamente porque tenía efectos adversos muy graves, como los ahí descritos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 67

Un lactante de 4 meses acude a su control de niño sano. Tiene antecedente de una invaginación intestinal a los 2 meses, ¿cuál de las siguientes vacunas está contraindicada en este paciente?

A VPO
B VPI
C Rotavirus oral
D Toxoide tetánico
E Toxoide diftérico

Respuesta C. La opción correcta es la C (Rotavirus oral). En este escenario clínico, rotavirus oral se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 68

Un lactante de 12 meses ha comido huevo en dos oportunidades y en ambas ha presentado un exantema eritematoso generalizado, sin otras manifestaciones. ¿Qué conducta es la más adecuada, respecto a la vacuna trivírica?

A Administrarla en este momento
B Eliminarla de su esquema de vacunación
C Administrarla a los 18 meses
D Esperar a los 4 años para administrarla
E Esperar a que esté en primero básico para administrarla

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Administrarla en este momento (opción A). La alergia al huevo no contraindica ninguna vacuna.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 87

Un lactante de 12 meses de edad, que a los 9 meses presentó un exantema, al introducir huevo a su alimentación por lo que fue suspendido, sin haberlo comido de nuevo. ¿Cuál es la conducta a tomar con repecho a la vacuna trivírica?

A Aplicar a los 12 meses
B Contraindicar la vacuna
C Aplicar a los 18 meses
D Diferir hasta los 2 años
E Realizar IgE específica del huevo y decidir según resultado

Respuesta A. La alergia al huevo actualmente no es contraindicación de la vacuna trivírica, a menos que haya requerido hospitalización, caso en el que igualmente se da la vacuna, pero en el hospital, bajo observación.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 15

Un lactante de 2 meses de edad, sin antecedentes perinatales, acude a control donde se le administran sus vacunas según el programa nacional de inmunizaciones, doce horas después presenta convulsión tonicoclónica generalizada que dura tres minutos evolucionando posteriormente en buenas condiciones. A futuro la conducta más adecuada con este paciente es:

A No volver a vacunar.
B Vacunar con DPT al año de vida
C Continuar calendario de vacunación de forma normal
D Indicar paracetamol durante la próxima vacunación
E Reemplazar DPT con DPT acelular.

Respuesta E. Fue una reacción a la Pertusis celular. Se debe cambiar por acelular. Hoy se usa la pentavalente y no la DPT, sin embargo es la única respuesta correcta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 2

¿Qué vacuna está contraindicada en un niño con antecedente de anafilaxia en relación a la ingesta de huevo?

A Vacuna neumocócica conjugada
B Vacuna tres vírica
C Vacuna antimeningocócica
D Vacuna antirrábica
E Vacuna contra la fiebre amarilla

Respuesta C. La opción correcta es la C (Vacuna antimeningocócica). En este escenario clínico, vacuna antimeningocócica se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 37

67) Un lactante de 4 meses acude a su control de niño sano. Tiene antecedente de una invaginación intestinal a los 2 meses, ¿cuál de las siguientes vacunas está contraindicada en este paciente?

A VPO
B VPI
C Rotavirus oral
D Toxoide tetánico
E Toxoide diftérico

Respuesta C. La opción correcta es la C (Rotavirus oral). En este escenario clínico, rotavirus oral se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

▶ VER CLASE 2.01.3.007 Lactancia materna

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.4 · Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)

QUÉ HAY QUE SABER

- Lactancia materna exclusiva 6 meses y complementada hasta los 2 años o más; inicio en la primera hora de vida con contacto piel a piel.
- Beneficios: niño (menos infecciones, diarrea, otitis, muerte súbita, obesidad, mejor desarrollo); madre (menos cáncer de mama y ovario, menor hemorragia posparto, espaciamiento de embarazos).
- Técnica: libre demanda (8-12 veces/día), buen acople (boca bien abierta, labio inferior evertido, más areola visible arriba, mentón tocando la mama); vaciar un pecho antes de ofrecer el otro.
- Problemas: grietas (corregir acople), congestión (vaciamiento frecuente), mastitis (continuar lactancia, cloxacilina o cefadroxilo + AINE), absceso (drenaje); hipogalactia: aumentar frecuencia.
- Contraindicaciones reales: VIH materno (en Chile), HTLV-1, galactosemia en el niño, quimioterapia, drogas de abuso; la mayoría de fármacos son compatibles. Hepatitis B, mastitis y fiebre no contraindican.
- Ley chilena: posnatal de 12 semanas + posnatal parental de 12 semanas; derecho a 1 hora diaria para alimentar hasta los 2 años; extracción y conservación de leche (refrigerador 3-5 días).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 109

Lactante de 3 meses, que pesa 7 kilos, alimentado con lactancia materna exclusiva a libre demanda. Su Peso para la Edad está en más 1 DE y su Peso para la Talla en más 2 DE. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Dar fórmula de relleno
B Amamantar cada 4 horas
C Dar agua entre cada toma
D Mantener la lactancia materna a libre demanda
E Suspender la lactancia nocturna

Respuesta D. Un Peso para la Talla de +2 DE corresponde a obesidad según los cortes de la OMS y el MINSAL. Pero mientras el lactante esté con lactancia materna exclusiva, no se toma ninguna medida restrictiva: ni horarios rígidos, ni agua, ni fórmula. Se mantiene la lactancia a libre demanda hasta los 6 meses.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 99

Usted atiende a un recién nacido de 10 días de vida, junto a su madre. Nació por parto vaginal sin complicaciones, pesando 3.200 gramos al nacer y 3.050 gramos al momento del alta. La madre refiere que presenta llanto frecuente y permanece constantemente prendido al pecho, por lo que sospecha que tiene dolor abdominal. Al examen físico, el niño llora vigorosamente y se observa en buen estado general. Su peso actual es de 3.350 gramos. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este caso?

A Agregar fórmula láctea después de cada toma
B Indicar a la madre que suspenda el consumo de lácteos y reevaluar al niño
C Citar a control en 24 horas
D Reforzar la técnica de lactancia materna
E Prescribir lactobacillus reuteri

Respuesta D. Peso en Recién Nacidos: Es normal que un recién nacido pierda hasta un 10% de su peso durante los primeros días de vida, el cual se recupera al cumplir los 7 días. Luego de la baja inicial, el incremento norma es de 20 a 25 g al día o más. En este caso, el recién nacido ha subido de peso adecuadamente, lo que sugiere que es un recién nacido normal. Por estar prendido al pecho todo el día, se asume que la técnica de lactancia no es óptima. Si no hubiese subido de peso, sería correcto mejorar la...

▶ VER CLASE 2.01.3.008 Prevención de accidentes

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.24 · Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes

QUÉ HAY QUE SABER

- Accidentes (lesiones no intencionales): principal causa de muerte en niños >1 año en Chile; tipo según edad.
- Lactante: asfixia (sueño seguro boca arriba, sin objetos en cuna), caídas (mudador, camas), quemaduras por líquidos calientes; no dejar solo en tina.

- Preescolar: intoxicaciones (medicamentos y productos de limpieza bajo llave y en envases originales), ahogamiento por inmersión (piscinas cercadas, supervisión permanente), aspiración de cuerpos extraños (no frutos secos <4-5 años), caídas desde altura (mallas en ventanas).
- Escolar y adolescente: accidentes de tránsito (silla de auto según peso y talla hasta ~1,35-1,50 m y asiento trasero hasta 12 años; casco en bicicleta), lesiones deportivas, consumo de alcohol.
- Silla de auto mirando hacia atrás el mayor tiempo posible (al menos hasta los 2 años); ley chilena de sillas obligatoria según edad/talla.
- Consejería anticipatoria en cada control de salud según etapa del desarrollo; CITUC para orientación en intoxicaciones.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En el control de salud de un lactante de 6 meses, los padres preguntan cómo deben trasladarlo en el automóvil. **¿Cuál es la recomendación correcta?**

A En brazos de un adulto en el asiento trasero

B En silla de auto en el asiento delantero frente al airbag

C En silla de auto mirando hacia adelante, en el asiento delantero

D Con el cinturón de seguridad del adulto

E En silla de auto mirando hacia atrás, en el asiento trasero

Respuesta E. Los accidentes son una causa principal de muerte en niños mayores de 1 año. Los lactantes deben viajar en un sistema de retención infantil mirando hacia atrás, en el asiento trasero, idealmente hasta los 2 años o más, porque protege cabeza y cuello. Nunca en brazos ni frente a un airbag activo.

▶ VER CLASE 2.01.3.009 Prevención de conductas de riesgo

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.28 · Pediatría Psicosocial: Maltrato Infantil, Entrevista Clínica, Conductas de Riesgo en el Adolescente y Psiquiatría de Enlace

QUÉ HAY QUE SABER

- Conductas de riesgo en adolescentes: consumo de tabaco, alcohol y drogas (marihuana), sexualidad no protegida, conducción riesgosa, violencia, conductas alimentarias de riesgo, uso problemático de pantallas.
- Pesquisa en control de salud del adolescente con entrevista confidencial (HEADSSS) y tamizaje CRAFFT para consumo de sustancias.
- Factores protectores: vínculo familiar, supervisión parental, escolaridad, actividades deportivas y recreativas, proyecto de vida, pares positivos.
- Salud sexual: educación, anticoncepción y preservativo (doble protección), acceso a consejería confidencial; anticoncepción de emergencia disponible.
- Intervención breve motivacional ante consumo; derivar a programa de salud mental o tratamiento de drogas (GES consumo perjudicial de alcohol y drogas en <20 años) si dependencia.
- Promoción: espacios amigables para adolescentes en APS, programa escolar de prevención (SENDA).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un adolescente de 15 años acude a control de salud. En la entrevista a solas, refiere que consume alcohol los fines de semana con sus amigos. No tiene síntomas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Informar inmediatamente a los padres

B No abordar el tema porque no tiene síntomas

C Derivar directamente a un centro de rehabilitación

D Realizar tamizaje estructurado de consumo (ej. CRAFFT) e intervención breve motivacional

E Solicitar test de drogas en orina sin su consentimiento

Respuesta D. La prevención de conductas de riesgo en adolescentes se basa en la entrevista confidencial (HEADSSS), el tamizaje estructurado de consumo de sustancias (CRAFFT) y la intervención breve con enfoque motivacional, ajustando el seguimiento al riesgo. La confidencialidad se mantiene salvo riesgo vital. Derivar a rehabilitación sin evaluar el nivel de consumo es desproporcionado.

▶ VER CLASE 2.01.3.010 Prevención de maltrato y abuso infantil

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.13 · Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

QUÉ HAY QUE SABER

- Maltrato infantil: físico, psicológico, negligencia, abuso sexual y exposición a violencia intrafamiliar; la prevención busca factores de riesgo antes de que ocurra.
- Factores de riesgo: padres jóvenes, depresión materna, consumo de alcohol/drogas, violencia en la pareja, aislamiento social, pobreza, embarazo no deseado; niño prematuro, con discapacidad o enfermedad crónica.
- Prevención primaria: Chile Crece Contigo (visitas domiciliarias, talleres de habilidades parentales «Nadie es Perfecto»), crianza respetuosa, apoyo a la lactancia y al vínculo.
- Educar en autocuidado corporal y diferenciar secretos buenos y malos; enseñar a pedir ayuda.
- Pesquisa en controles: lesiones no explicadas, cambios conductuales, retraso del desarrollo, inasistencia a controles.
- Ante sospecha: proteger, registrar y denunciar (obligación legal del médico) y activar la red (OPD, Tribunal de Familia, Fiscalía).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una niña de 6 años es traída por su madre, quien relata que la niña le contó que un familiar le tocó los genitales. Al examen no hay lesiones físicas. **¿Cuál es la conducta más adecuada del médico?**

A Interrogar a la niña en detalle varias veces para confirmar el relato

B Descartar el abuso por la ausencia de lesiones

C Proteger a la niña, registrar el relato textual y realizar la denuncia dentro de las 24 horas

D Citar al familiar para confrontarlo

E Esperar a que la madre decida si denuncia

Respuesta C. Ante sospecha de abuso sexual infantil, el médico debe proteger al niño, registrar textualmente lo relatado sin interrogatorios repetidos (para evitar revictimización) y denunciar: el Código Procesal Penal obliga a los profesionales de salud a hacerlo dentro de 24 horas. La ausencia de lesiones no descarta el abuso, que con frecuencia no deja hallazgos.

▶ VER CLASE 2.01.3.011 Promoción de salud y estilos de vida saludables

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.1 · Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Promoción de estilos de vida saludables: alimentación saludable (guías alimentarias chilenas), actividad física, sueño suficiente, salud mental y entornos libres de tabaco.
- Actividad física: ≥60 min/día de intensidad moderada a vigorosa en escolares y adolescentes; preescolares ≥3 h/día de actividad lúdica.
- Pantallas: evitar en <2 años; máximo 1 h/día en 2-5 años; limitar y supervisar en mayores; sin pantallas en el dormitorio ni antes de dormir.
- Alimentación: lactancia materna, evitar bebidas azucaradas y ultraprocesados (ley de etiquetado con sellos «alto en»), 5 porciones de frutas y verduras, agua como bebida principal.
- Sueño recomendado: lactantes 12-16 h, preescolares 10-13 h, escolares 9-12 h, adolescentes 8-10 h.
- Programas: Elige Vivir Sano, Chile Crece Contigo, escuelas promotoras de salud; consejería en cada control de salud.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En el control de salud de un escolar de 8 años, la madre pregunta cuánta actividad física y tiempo frente a pantallas son recomendables. **¿Cuál es la recomendación correcta?**

A Al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa y limitar el tiempo recreativo frente a pantallas

B 30 minutos de actividad física 2 veces por semana

C Actividad física solo si tiene sobrepeso

D Pantallas sin límite si realiza deporte

E Evitar la actividad vigorosa antes de los 12 años

Respuesta A. La OMS y MINSAL recomiendan que niños y adolescentes de 5 a 17 años realicen al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa, incluyendo actividades de fortalecimiento muscular 3 veces por semana, y limitar el tiempo sedentario recreativo frente a pantallas (idealmente menos de 2 horas al día).

▶ VER CLASE 2.01.3.012 Psiquiatría de enlace

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.28 · Pediatría Psicosocial: Maltrato Infantil, Entrevista Clínica, Conductas de Riesgo en el Adolescente y Psiquiatría de Enlace

QUÉ HAY QUE SABER

- Psiquiatría de enlace pediátrica: atención de salud mental del niño hospitalizado o con enfermedad médica, y de su familia.
- Situaciones frecuentes: delirium (fluctuación de conciencia, inatención; tratar causa médica, medidas ambientales, haloperidol/risperidona en agitación), ansiedad y depresión en enfermedad crónica, intento suicida, trastornos de la conducta alimentaria, síntomas somáticos sin explicación médica.
- Trastornos de síntomas somáticos y conversivos: síntomas reales no explicados por enfermedad; evitar estudios excesivos, validar, rehabilitación funcional y psicoterapia.
- Adherencia a tratamiento en enfermedades crónicas (DM1, FQ, oncológicos): evaluar factores psicosociales y familiares.
- Preparación para procedimientos dolorosos, manejo del dolor y acompañamiento de los padres; cuidados paliativos pediátricos cuando corresponda.
- Interconsultar a psiquiatría infantojuvenil ante riesgo suicida, psicosis, delirium refractario o patología psiquiátrica que interfiere con el tratamiento médico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una adolescente de 14 años con diabetes mellitus tipo 1 ha tenido tres hospitalizaciones por cetoacidosis en 6 meses. Reconoce que omite dosis de insulina. Refiere ánimo bajo, aislamiento y conflictos familiares desde el diagnóstico. **Además de reforzar la educación en diabetes, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Aumentar la dosis de insulina basal

B Hospitalizar hasta que cumpla 18 años

C Indicar que cumpla mejor el tratamiento y control en 3 meses

D Cambiar a hipoglicemiantes orales

E Solicitar interconsulta a salud mental (psiquiatría de enlace) para evaluación integral

Respuesta E. La mala adherencia en adolescentes con enfermedades crónicas se asocia frecuentemente a depresión, trastornos de la conducta alimentaria (omisión de insulina para bajar de peso) y conflictos familiares. La psiquiatría de enlace evalúa y trata en conjunto con el equipo tratante, mejorando el control metabólico.

▶ VER CLASE 2.01.3.013 Relación médico-paciente-familia

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.11 · Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Relación médico-paciente en pediatría es triangular: niño, familia y médico; los padres son los representantes legales, pero se respeta la autonomía progresiva del niño.
- Modelos: paternalista, informativo, deliberativo; preferir el modelo deliberativo/centrado en la familia con decisiones compartidas.
- Ley 20.584 de derechos y deberes de los pacientes: información veraz y comprensible, consentimiento informado, confidencialidad, trato digno, acompañamiento.
- Consentimiento informado de los padres y asentimiento del niño según su madurez; adolescente puede recibir consejería confidencial en salud sexual.
- Conflictos (rechazo de tratamiento vital, vacunas): dialogar, informar riesgos, buscar consenso; ante riesgo vital del niño, recurrir al comité de ética o tribunales.
- Empatía, comunicación clara, manejo de expectativas y continuidad de la atención fortalecen la adherencia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 8 años llega a urgencia con hemorragia masiva tras un accidente y requiere transfusión inmediata para salvar su vida. Sus padres, por motivos religiosos, se oponen a la transfusión. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Respetar la decisión de los padres y no transfundir

B Transfundir, ya que en una urgencia con riesgo vital de un menor prima su derecho a la vida, informando y dejando registro

C Esperar una orden judicial antes de cualquier acción

D Trasladar al niño a otro centro

E Pedir al niño que decida

Respuesta B. Los padres representan a sus hijos, pero su decisión debe resguardar el mejor interés del niño. La Ley 20.584 permite actuar sin consentimiento ante una urgencia con riesgo vital inminente. Se debe intentar dialogar con la familia, transfundir, registrar en la ficha y, si la situación no es urgente, solicitar autorización judicial o del comité de ética.

▶ VER CLASE 2.01.3.014 Salud infantil en Chile y el mundo

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.7 · Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

QUÉ HAY QUE SABER

- Chile tiene indicadores de salud infantil comparables a países desarrollados: mortalidad infantil ~6-7 por 1.000 nacidos vivos, explicada principalmente por mortalidad neonatal.
- Causas de mortalidad infantil: afecciones perinatales (prematurez) y malformaciones congénitas; en >1 año, causas externas (accidentes) y cáncer.
- Logros históricos: control de enfermedades infecciosas y desnutrición gracias a PNI, PNAC, atención profesional del parto, saneamiento y educación materna.
- Problemas actuales: obesidad infantil (alta prevalencia en escolares, mapa nutricional JUNAEB), salud mental, maltrato, bajos indicadores de lactancia sostenida.
- Globalmente: principales causas de muerte en <5 años son complicaciones neonatales, neumonía, diarrea y malaria; Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan reducir mortalidad neonatal y de <5 años.
- Programas chilenos: Chile Crece Contigo (sistema de protección integral a la infancia), programa nacional de salud de la infancia, GES pediátricos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En un informe sobre salud infantil en Chile se analiza la tasa de mortalidad infantil, que actualmente es cercana a 6 por 1.000. **¿Cómo se calcula la tasa de mortalidad infantil y cuál es su principal causa en Chile?**

A Muertes de menores de 5 años por 1.000 habitantes; causa principal: infecciones respiratorias

B Muertes de menores de 1 año por 1.000 habitantes; causa principal: diarrea

C Muertes de menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos; causa principal: afecciones originadas en el período perinatal

D Muertes de menores de 28 días por 1.000 nacidos vivos; causa principal: accidentes

E Muertes fetales por 1.000 partos; causa principal: malformaciones

Respuesta C. La tasa de mortalidad infantil es el número de muertes de menores de 1 año en un período, dividido por los nacidos vivos del mismo período, por 1.000. Chile tiene una de las tasas más bajas de Latinoamérica. Sus principales causas son las afecciones originadas en el período perinatal (prematurez) y las malformaciones congénitas; las infecciones disminuyeron drásticamente.

▶ VER CLASE 2.01.3.015 Salud oral

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.2 · Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos

QUÉ HAY QUE SABER

- Caries: enfermedad infecciosa (Streptococcus mutans) multifactorial, muy prevalente en Chile; caries temprana de la infancia asociada a mamadera nocturna con líquidos azucarados.
- Higiene: limpiar encías desde el nacimiento; cepillado desde la erupción del primer diente con pasta fluorada (≥1.000 ppm), cantidad tamaño grano de arroz en <3 años y arveja en ≥3 años, 2 veces al día, supervisado por adulto.
- Dieta: evitar azúcar y bebidas azucaradas, no dormir con mamadera, retirar mamadera cerca de los 12-18 meses.
- Fluoración del agua potable, barniz de flúor y sellantes en programas escolares; primer control odontológico desde la erupción o al año.
- Programa CERO (control con enfoque de riesgo odontológico) en <20 años y GES salud oral integral para niños de 6 años y embarazadas.
- Erupción: primer diente ~6 meses, dentición temporal completa (20) a los 2-3 años; primer molar definitivo a los 6 años; derivar si traumatismo dentario (avulsión de diente definitivo: reimplantar o transportar en leche).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una madre consulta qué atención dental cubre el GES para su hijo. **¿Qué grupo de edad pediátrico tiene garantizada por el GES la salud oral integral?**

A Preescolares de 4 años solamente

B Lactantes de 6 meses

C Adolescentes de 15 años

D Todos los menores de 18 años

E Niños y niñas de 6 años

Respuesta E. El GES incluye "Salud oral integral para niños y niñas de 6 años", que cubre examen, educación, prevención (sellantes, flúor) y tratamiento de caries, en el momento en que erupcionan los primeros molares definitivos. Otras garantías odontológicas son la salud oral de la embarazada y la urgencia odontológica ambulatoria.

▶ VER CLASE 2.01.3.016 Supervisión de salud- adolescente

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.12 · Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad

QUÉ HAY QUE SABER

- Control de salud integral del adolescente (10-19 años): anual en APS o en espacio amigable, con entrevista confidencial y ficha CLAP.
- Evaluar: crecimiento y estado nutricional (IMC), PA, desarrollo puberal (Tanner), agudeza visual, escoliosis (test de Adams), acné, salud oral.
- Pauta HEADSSS: hogar, educación, actividades, drogas (CRAFFT), sexualidad, suicidio/ánimo (tamizaje de depresión), seguridad (violencia, bullying, ciberacoso).
- Consejería: salud sexual y reproductiva (preservativo, anticoncepción), prevención de consumo de sustancias, alimentación y actividad física, uso de pantallas y sueño.
- Vacunas: dTpa en 8º básico, VPH, influenza según grupo; revisar esquema.
- Derivar ante riesgo suicida, consumo problemático, trastorno de conducta alimentaria, embarazo, violencia o abuso.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una adolescente de 15 años acude a control de salud con su madre. Usted planea aplicar la entrevista psicosocial HEADSSS. **¿Cuál es la forma más adecuada de realizar la entrevista?**

A Una parte a solas con la adolescente, explicando la confidencialidad y sus límites

B Siempre con la madre presente para validar la información

C Solo con la madre, porque la adolescente es menor de edad

D Por escrito, sin conversación

E Prometer confidencialidad absoluta en cualquier circunstancia

Respuesta A. En el control de salud del adolescente se entrevista primero con el acompañante y luego a solas, explicando que la información es confidencial excepto si existe riesgo para su vida o la de otros, o abuso. La entrevista HEADSSS explora hogar, educación, actividades, drogas, sexualidad, suicidio y seguridad. Prometer confidencialidad absoluta es incorrecto.

▶ VER CLASE 2.01.3.017 Supervisión de salud- escolar

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.1 · Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Supervisión de salud del escolar (6-9 años): controles periódicos (al menos a los 6, 7, 8 y 9 años en APS o en el colegio, programa JUNAEB de salud escolar).
- Evaluar crecimiento (talla, IMC/E, curva), PA, agudeza visual (Snellen), audición, salud oral, postura y columna, desarrollo puberal precoz.
- Pesquisar rendimiento escolar, problemas de aprendizaje y atención (TDAH), conducta, bullying, ánimo, sueño y uso de pantallas.
- Vacunas escolares: dTpa en 1º y 8º básico y VPH en 4º-5º básico (revisar que tenga 2ª dosis de tresvírica y varicela); influenza según campaña.
- Consejería: alimentación saludable (colaciones sin ultraprocesados), ≥60 min/día de actividad física, prevención de accidentes (silla elevadora, casco), higiene dental, sexualidad y autocuidado.
- Derivar si talla baja, obesidad con comorbilidad, HTA, déficit visual/auditivo, problemas de aprendizaje o conducta.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En el control de salud de un niño de 7 años, sano, se revisan los exámenes y mediciones que deben realizarse. **¿Cuál de las siguientes mediciones debe incluirse en el control de salud del escolar?**

A Radiografía de columna anual

B Electrocardiograma anual

C Hemograma anual

D Presión arterial, al menos una vez al año desde los 3 años

E Glicemia de ayuno anual

Respuesta D. El control de salud escolar incluye antropometría con diagnóstico nutricional, presión arterial (desde los 3 años, anual), agudeza visual y auditiva, salud bucal, desarrollo puberal, evaluación de escoliosis al examen físico y aspectos psicosociales y escolares. Los exámenes de laboratorio o radiografías no se solicitan de rutina en un niño sano.

▶ VER CLASE 2.01.3.018 Supervisión de salud- lactante

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.1 · Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Supervisión de salud del lactante: controles frecuentes (díada a los 7-10 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 18 meses) en el programa de salud infantil.
- Evaluar: antropometría con curvas OMS (peso, talla, perímetro craneano), desarrollo psicomotor (EEDP 8 y 18 meses), alimentación, examen físico completo.
- Pesquisas específicas: displasia de caderas (Ortolani-Barlow; Rx de pelvis a los 3 meses), reflejo rojo (cataratas, retinoblastoma), testículos, soplos, hernias; depresión posparto (Edimburgo a los 2 y 6 meses).
- Suplementos: vitamina D 400 UI/día hasta 12 meses; hierro desde los 4 meses (2 meses en prematuros); vacunas a los 2, 4, 6, 12 y 18 meses; PNAC.
- Consejería: lactancia materna exclusiva, sueño seguro boca arriba, prevención de accidentes, estimulación, alimentación complementaria desde los 6 meses.
- Derivar ante falla de crecimiento, retraso del desarrollo, alteraciones del examen o factores de riesgo psicosocial (Chile Crece Contigo).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 17

Un lactante de 11 meses acude a control de niño sano, constatándose que aún no tiene ningún diente. El resto de su examen físico, así como su desarrollo psicomotor, es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Derivar al odontopediatra

B Solicitar radiografía panorámica dentaria

C Solicitar TSH plasmática

D Solicitar niveles plasmáticos de vitamina D

E Observar evolución y controlar en 2 meses

Respuesta E. La erupción del primer diente suele ocurrir alrededor de los 6 meses, pero tiene amplia variabilidad y puede retrasarse hasta los 12 a 15 meses en niños sanos. Con crecimiento y desarrollo normales, la conducta es observar. Se estudia (radiografía, causas sistémicas como hipotiroidismo o raquitismo) si no hay dientes a los 15 a 18 meses o hay otros hallazgos.

▶ VER CLASE 2.01.3.019 **Supervisión de salud- pre-escolar**

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.2 · Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Supervisión de salud del preescolar (2-5 años): controles a los 2, 3, 4 y 5 años en programa de salud infantil.
- Evaluar: crecimiento (P/T hasta 5 años y luego IMC/E, T/E), PA desde los 3 años, desarrollo psicomotor (TEPSI a los 3 años), lenguaje, conducta y control de esfínteres.
- Pesquisas: agudeza visual desde los 4 años (estrabismo, ambliopía), audición, salud oral (programa CERO), pie plano, fimosis, criptorquidia.
- Consejería: alimentación familiar saludable sin bebidas azucaradas, actividad física diaria, pantallas ≤1 h/día, sueño 10-13 h, prevención de accidentes (intoxicaciones, ahogamiento, silla de auto), crianza respetuosa.
- Revisar vacunas (incluida campaña influenza) y suplementación según necesidad.
- Derivar si retraso del desarrollo o lenguaje, malnutrición, problemas de conducta (berrinches extremos, TEA) o déficit sensorial.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 3 años acude a su control de salud en atención primaria. Corresponde evaluar su desarrollo psicomotor con un instrumento estandarizado. **¿Qué instrumento corresponde aplicar a esta edad?**

A EEDP (Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor)

B TEPSI (Test de Desarrollo Psicomotor)

C Test de Denver como único instrumento obligatorio

D Escala de Wechsler

E Score de Apgar

Respuesta B. En Chile, el desarrollo psicomotor se evalúa con EEDP entre los 0 y 2 años (en controles de 8 y 18 meses) y con TEPSI entre los 2 y 5 años (en el control de 3 años), que evalúa coordinación, lenguaje y motricidad. Un resultado de riesgo o retraso requiere estimulación y reevaluación o derivación.

Exámenes e imagenología

26 códigos

▶ VER CLASE 2.01.4.001 **Radiografía de tórax** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.7 · Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Pediátrica: Diagnóstico, Amoxicilina vs Ampicilina y Criterios de Hospitalización

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: sospecha de neumonía con dudas o gravedad, hospitalización, evolución tórpida, sospecha de complicación (derrame, neumotórax), cuerpo extraño, cardiopatía. No se requiere en NAC leve ambulatoria ni en bronquiolitis típica.
- Técnica: AP/PA de pie en mayores y AP en decúbito en lactantes; evaluar calidad (inspiración: 6 arcos anteriores, rotación, penetración).
- Hallazgos: condensación lobar con broncograma aéreo (neumococo), infiltrado intersticial difuso (virus, Mycoplasma), hiperinsuflación y atelectasias (bronquiolitis, asma), velamiento del seno costofrénico (derrame; decúbito lateral para cuantificar).
- Particularidades pediátricas: timo normal en lactantes (signo de la vela) no debe confundirse con condensación; neumonía redonda en niños.
- Cuerpo extraño: Rx en inspiración-espiración con atrapamiento aéreo unilateral; cardiopatías: cardiomegalia (índice cardiotorácico >0,6 en lactantes, >0,5 en niños), flujo pulmonar aumentado o disminuido, corazón en bota (Fallot), huevo en hilo (TGA).
- No pedir Rx de control de rutina en neumonía con buena evolución; solo si persisten síntomas, neumonía complicada o recurrente.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 3 años con diagnóstico clínico de neumonía, en tratamiento con amoxicilina oral en dosis alta. Tras 48 horas persiste con fiebre de 39 °C y dolor en el costado derecho. Al examen: FR 40 rpm, saturación 94%, matidez y murmullo pulmonar disminuido en la base derecha. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Cambiar a azitromicina oral y control en 48 horas

B Solicitar TAC de tórax ambulatoria

C Mantener la amoxicilina y esperar 48 horas más

D Agregar salbutamol inhalado

E Hospitalizar y solicitar radiografía de tórax por sospecha de derrame pleural

Respuesta E. La radiografía de tórax no es de rutina en la neumonía infantil, pero está indicada si no hay respuesta a las 48 horas o se sospecha una complicación. Fiebre persistente con matidez y murmullo disminuido sugieren derrame pleural paraneumónico, que obliga a hospitalizar.

▶ VER CLASE 2.01.4.002 Radiografía de abdomen simple

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.3 · Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: sospecha de obstrucción intestinal, perforación (neumoperitoneo), enterocolitis necrotizante, cuerpo extraño radioopaco ingerido, malformaciones digestivas neonatales.
- Proyecciones: AP en decúbito y de pie (o decúbito lateral con rayo horizontal en lactantes) para niveles hidroaéreos y aire libre.
- Obstrucción: asas dilatadas con niveles hidroaéreos y ausencia de gas distal; doble burbuja (atresia duodenal), triple burbuja (atresia yeyunal), ausencia de gas rectal (Hirschsprung, atresias).
- ECN: neumatosis intestinal (patognomónica), gas en vena porta, asa fija; neumoperitoneo (perforación) requiere cirugía.
- Invaginación: puede mostrar masa de partes blandas y escaso gas en fosa ilíaca derecha, pero la ecografía es el examen de elección. Constipación: no se requiere Rx para diagnosticar.
- Cuerpo extraño: pila de botón en esófago (doble halo) es urgencia endoscópica; imanes múltiples también.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un recién nacido con síndrome de Down presenta, a las 12 horas de vida, vómitos biliosos sin distensión abdominal. La madre tuvo polihidroamnios. La radiografía simple de abdomen muestra dos burbujas de aire (estómago y duodeno proximal) sin aire distal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Atresia duodenal

B Estenosis hipertrófica del píloro

C Enfermedad de Hirschsprung

D Íleo meconial

E Enterocolitis necrotizante

Respuesta A. El signo de la doble burbuja sin aire distal en la radiografía simple de abdomen, con vómitos biliosos precoces, polihidroamnios y síndrome de Down (asociación frecuente) es atresia duodenal. Se maneja con sonda nasogástrica, hidratación y duodeno-duodenostomía. La estenosis pilórica da vómitos no biliosos a las 3 a 6 semanas; Hirschsprung e íleo meconial dan distensión y múltiples asas dilatadas.

▶ VER CLASE 2.01.4.003 Ecotomografía abdominal

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.13 · Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Examen de primera línea en pediatría: no irradia, no requiere sedación y está disponible.
- Indicaciones: dolor abdominal localizado (apendicitis: apéndice >6 mm no compresible), invaginación intestinal (signo de diana o pseudoriñón), estenosis hipertrófica del píloro (grosor muscular ≥3-4 mm, longitud ≥15-17 mm), masa abdominal.
- Riñón y vía urinaria: tras primera ITU febril (hidronefrosis, malformaciones, dilatación ureteral), hidronefrosis antenatal (realizar después de 48-72 h de vida), HTA, hematuria.
- Hígado y vía biliar: colestasia del lactante (signo del cordón triangular, vesícula ausente o pequeña en atresia de vías biliares), hepatomegalia, litiasis.
- Trauma abdominal: FAST para líquido libre en paciente inestable; TC en estables con sospecha de lesión de víscera sólida.
- Masa: diferenciar quística vs sólida, órgano de origen (Wilms renal vs neuroblastoma suprarrenal); el informe orienta la derivación a especialista.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 10 meses, sin antecedentes, con su primer episodio de infección urinaria febril, confirmado por urocultivo tomado por sondeo vesical. Evolucionó afebril a las 36 horas de tratamiento y completó el antibiótico. No tiene antecedentes prenatales de malformaciones. **¿Cuál es el estudio de imágenes más adecuado?**

A Ninguno, porque respondió bien al tratamiento

B Ecografía renal y vesical

C Uretrocistografía miccional como primer examen

D TAC de abdomen y pelvis

E Radiografía simple de abdomen

Respuesta B. A todo niño con una primera infección urinaria febril comprobada se le pide ecografía renal y vesical, para buscar malformaciones y dilatación de la vía urinaria. La uretrocistografía se reserva para cuando la ecografía sale alterada o el cuadro es atípico o recurrente.

▶ VER CLASE 2.01.4.004 Radiografía de cavum

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.15 · Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Radiografía de cavum (lateral de nasofaringe): evalúa el tamaño del tejido adenoideo en relación con el espacio aéreo nasofaríngeo.
- Indicación: sospecha de hipertrofia adenoidea con respiración bucal, ronquido, voz nasal, otitis media recurrente o con efusión, sinusitis recurrente; en niños >2-3 años.
- Interpretación del informe: relación adenoide/nasofaringe (A/N): >0,6-0,7 indica hipertrofia obstructiva significativa.
- Limitaciones: imagen estática, irradia; la nasofibroscopía es el estándar para evaluar obstrucción dinámica.
- Hipertrofia significativa sintomática: derivar a ORL para evaluar adenoidectomía; leve-moderada: corticoide intranasal por 6-12 semanas.
- No reemplaza la polisomnografía para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 4 años ronca todas las noches, respira por la boca, tiene voz nasal y rinorrea persistente. Sus padres han notado pausas respiratorias durante el sueño. A la orofaringe las amígdalas son pequeñas. **¿Qué examen permite evaluar el tamaño del tejido adenoideo?**

A Radiografía de senos paranasales

B Radiografía de tórax

C Radiografía lateral de cavum

D TAC de cerebro

E Audiometría

Respuesta C. Ronquido, respiración bucal, voz nasal y apneas con amígdalas pequeñas sugieren hipertrofia adenoidea. La radiografía lateral de cavum permite estimar la relación adenoides/nasofaringe y la obstrucción de la vía aérea; también puede usarse la nasofibroscopía. Con SAHOS y adenoides obstructivos, el tratamiento es la adenoidectomía (o adenoamigdalectomía).

▶ VER CLASE 2.01.4.005 Radiografía de cráneo

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Cirugía** 11.12 · Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

QUÉ HAY QUE SABER

- Rx de cráneo tiene utilidad limitada; en TEC la TC es el examen de elección cuando está indicada (reglas PECARN).
- Indicaciones actuales: evaluación de craneosinostosis (cierre prematuro de suturas, forma craneal anormal), serie ósea en sospecha de maltrato en <2 años, sospecha de fractura deprimida en lactante cuando no se dispone de TC.
- Hallazgos en el informe: fracturas lineales o deprimidas, suturas cerradas o diastasadas (hipertensión endocraneana), lesiones líticas (histiocitosis de células de Langerhans), calcificaciones.
- Una Rx normal no descarta lesión intracraneana: no usar para decidir alta en TEC con criterios de riesgo.
- Fractura de cráneo en lactante sin mecanismo explicado: sospechar maltrato y completar estudio (TC, fondo de ojo, serie ósea).
- Plagiocefalia posicional (aplanamiento occipital con oreja desplazada hacia adelante) es clínica y no requiere Rx; craneosinostosis sí se deriva a neurocirugía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 3 años se cae de una silla de 50 cm de altura y se golpea la frente. No perdió la conciencia, no ha vomitado, está activo, juega con normalidad, tiene Glasgow 15 y solo un pequeño hematoma frontal. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la radiografía de cráneo?**

A Solicitar radiografía de cráneo para descartar fractura

B Solicitar radiografía y TAC de cerebro

C Solicitar radiografía de cráneo y, si es normal, dar el alta

D Solicitar radiografía de cráneo y columna cervical

E No solicitar radiografía: observar y dar indicaciones de alarma

Respuesta E. La radiografía de cráneo no se recomienda en el TEC pediátrico: una radiografía normal no descarta lesión intracraneana y una fractura no siempre la implica. En un TEC leve de bajo riesgo (mecanismo menor, Glasgow 15, sin pérdida de conciencia, vómitos ni hematoma no frontal), se observa y se educa sobre signos de alarma.

▶ VER CLASE 2.01.4.006 Radiografía de edad ósea

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.1 · Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Radiografía de mano y muñeca izquierda AP: estima la maduración ósea comparando con atlas (Greulich y Pyle) o método TW.
- Indicaciones: talla baja, talla alta, pubertad precoz o retrasada, evaluación del crecimiento remanente.
- Edad ósea retrasada (>2 DE o >2 años): retraso constitucional del crecimiento, hipotiroidismo, déficit de GH, desnutrición, enfermedades crónicas, Cushing.
- Edad ósea concordante con edad cronológica: talla baja familiar (variante normal). Adelantada: pubertad precoz, hiperplasia suprarrenal congénita, obesidad, hipertiroidismo.
- Permite predecir la talla adulta y el potencial de crecimiento remanente.
- Interpretación junto con curva de crecimiento y talla diana; derivar a endocrinología infantil si discordancia patológica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 10 años consulta por talla baja. Crece en el percentil 3 con velocidad de crecimiento normal y está sano. Su padre mide 160 cm y su madre 148 cm. Se solicita radiografía de carpo para edad ósea. **Si el diagnóstico es talla baja familiar, ¿cuál es el resultado esperado de la edad ósea?**

A Retrasada en más de 2 años respecto de la edad cronológica

B Muy retrasada con epífisis abiertas e irregulares

C Adelantada en más de 2 años

D Acorde a la edad cronológica

E No es posible estimarla antes de la pubertad

Respuesta D. La edad ósea ayuda a diferenciar las variantes normales de talla baja. En la talla baja familiar la edad ósea concuerda con la cronológica, la velocidad de crecimiento es normal y la talla es acorde a la talla diana. En el retraso constitucional la edad ósea está retrasada y la pubertad será tardía.

▶ VER CLASE 2.01.4.007 Radiografía de pelvis anteroposterior

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.22 · Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik

QUÉ HAY QUE SABER

- Radiografía de pelvis AP: tamizaje universal de displasia del desarrollo de caderas a los 3 meses en Chile (GES), cuando aparece el núcleo de osificación o se puede medir el acetábulo.
- Antes de los 3 meses la ecografía es de elección (cabeza femoral cartilaginosa) si hay factores de riesgo o examen alterado.
- Parámetros: línea de Hilgenreiner (horizontal por cartílagos trirradiados) y Perkins (vertical por borde acetabular): cuadrantes de Putti; cabeza en cuadrante superoexterno indica luxación.
- Índice acetabular aumentado (>30° a los 3 meses) indica displasia; arco de Shenton roto sugiere subluxación/luxación; retraso o asimetría del núcleo de osificación.
- Otras indicaciones: cojera en niños mayores (Perthes: necrosis avascular de la cabeza femoral en 4-8 años; epifisiólisis en adolescentes obesos: pedir también proyección de Lauenstein/rana).
- Informe alterado: derivar a traumatología infantil.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante femenina de 3 meses, nacida de término en presentación podálica. En su control sano, la cadera está estable al examen, sin resaltos. Se toma radiografía de pelvis por la Garantía Explícita en Salud: cadera derecha con núcleo en cuadrante ínfero-interno e índice acetabular de 26 grados; cadera izquierda con núcleo en cuadrante súpero-externo, índice acetabular de 38 grados y arco de Shenton roto. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener controles habituales, ya que el examen físico es normal

B Derivar a traumatología infantil e instalar correas de Pavlik

C Indicar doble pañal y control ecográfico en un mes

D Solicitar resonancia magnética de caderas antes de decidir

E Programar osteotomía femoral de urgencia

Respuesta B. La radiografía muestra displasia franca en la cadera izquierda (núcleo súpero-externo, índice acetabular sobre 30 y arco de Shenton roto), a pesar de que el examen físico ya no la detecta a esta edad. La conducta es derivar y comenzar de inmediato con correas de Pavlik, el estándar en menores de 6 meses.

▶ VER CLASE 2.01.4.008 Radiografía de senos paranasales

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Otorrino** 14.10 · Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

QUÉ HAY QUE SABER

- Rx de senos paranasales (Waters) tiene baja sensibilidad y especificidad; no se recomienda de rutina para diagnosticar sinusitis aguda, que es clínica.
- Desarrollo de senos: etmoidales y maxilares presentes desde el nacimiento (visibles radiológicamente después de 1 año en maxilares), esfenoidales hacia los 5 años y frontales a los 6-10 años; no interpretar senos frontales en niños pequeños.
- Hallazgos compatibles con sinusitis: nivel hidroaéreo, opacificación completa o engrosamiento mucoso >4 mm; pueden encontrarse en resfrío común.
- Indicaciones limitadas: sinusitis recurrente o crónica (preferir TC), sospecha de complicación (TC con contraste de órbita y senos), cuerpo extraño.
- Celulitis orbitaria o complicación intracraneana: TC urgente, no Rx.
- Interpretar siempre en contexto clínico: imagen anormal sin síntomas no indica antibiótico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 6 años presenta rinorrea purulenta y tos diurna persistente de 12 días de evolución, sin mejoría. Está afebril y en buenas condiciones generales, sin edema periorbitario. La madre pide una radiografía de senos paranasales. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la radiografía?**

A Solicitarla para confirmar el diagnóstico de sinusitis

B Solicitar radiografía y esperar el resultado para indicar antibiótico

C Solicitar TAC de senos paranasales

D No solicitarla: el diagnóstico de rinosinusitis aguda es clínico

E Solicitar resonancia magnética

Respuesta D. La rinosinusitis bacteriana aguda en niños se diagnostica clínicamente: síntomas persistentes más de 10 días sin mejoría, empeoramiento tras mejoría inicial o inicio grave. La radiografía de senos paranasales no se recomienda porque tiene baja especificidad (se altera en resfríos comunes) y los senos están en desarrollo. La TAC se reserva para sospecha de complicaciones orbitarias o intracraneanas.

▶ VER CLASE 2.01.4.009 Radiografía esófago- estómago- duodeno

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.3 · Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

QUÉ HAY QUE SABER

- Esófago-estómago-duodeno (EED) con contraste baritado: evalúa anatomía del tubo digestivo alto, no es el examen diagnóstico de reflujo.
- Indicaciones: sospecha de malrotación intestinal (ángulo de Treitz mal posicionado; vólvulo en «tirabuzón»), vómitos persistentes o biliosos, disfagia, estenosis esofágica, anillos vasculares (impronta posterior), acalasia, fístula traqueoesofágica en H.
- Reflujo gastroesofágico: el EED puede mostrar reflujo, pero su presencia no confirma ERGE; diagnóstico es clínico o con pH-impedanciometría.
- Estenosis hipertrófica del píloro: signo de la cuerda, aunque la ecografía es de elección.
- Contraindicado en sospecha de perforación (usar contraste hidrosoluble); precaución con aspiración en lactantes con trastorno de deglución.
- Malrotación con vólvulo en informe es urgencia quirúrgica: derivar de inmediato a cirugía infantil.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 3 semanas, previamente sano, presenta en forma brusca vómitos biliosos (verdes), irritabilidad y leve distensión abdominal. Está hemodinámicamente estable. **¿Cuál es el examen más adecuado para descartar la causa más grave?**

A Radiografía de esófago, estómago y duodeno con contraste (tránsito intestinal alto)

B Ecografía pilórica

C pH-metría esofágica

D Endoscopía digestiva alta

E Control ambulatorio en 48 horas

Respuesta A. Vómitos biliosos en un lactante son una emergencia quirúrgica hasta descartar malrotación intestinal con vólvulo del intestino medio, que puede llevar a necrosis intestinal en horas. El examen de elección, si el paciente está estable, es la radiografía de esófago, estómago y duodeno con contraste, que muestra la posición anormal del ángulo de Treitz o la imagen en sacacorchos.

▶ VER CLASE 2.01.4.010 Citoquímico de líquido cefaloraquídeo y pleural

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 3.2 · Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

QUÉ HAY QUE SABER

- LCR normal (>2 meses): <5 leucocitos/mm³ (hasta 20-30 en RN), glucosa >40 mg/dL o >60% de la glicemia, proteínas <40 mg/dL (hasta 150 en RN).
- Meningitis bacteriana: >1.000 células con predominio PMN, glucosa baja, proteínas altas; Gram, cultivo, látex o PCR. Viral: <500 células con predominio mononuclear (puede iniciar con PMN), glucosa normal, proteínas normales o levemente altas.
- Tuberculosa: pleocitosis linfocitaria, glucosa muy baja, proteínas muy altas (>100), ADA elevada; punción traumática: corregir 1 leucocito por cada 500-1.000 GR.
- Líquido pleural: criterios de Light para exudado (proteínas pleura/suero >0,5, LDH pleura/suero >0,6 o LDH >2/3 del límite normal sérico).
- Derrame paraneumónico complicado/empiema: pH <7,2, glucosa <40 mg/dL, LDH >1.000 UI/L, pus o Gram/cultivo positivo: requiere drenaje pleural.
- Interpretar con glicemia simultánea y antes de antibióticos; enviar citoquímico, Gram y cultivo siempre.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 5 años con neumonía en tratamiento antibiótico persiste febril al cuarto día. La radiografía muestra derrame pleural moderado. Se realiza toracocentesis, que obtiene líquido turbio con pH 7,0, glucosa 25 mg/dL y LDH 1.800 UI/L. La tinción de Gram muestra cocáceas grampositivas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Mantener el mismo antibiótico y controlar con radiografía en 1 semana

B Agregar corticoides sistémicos

C Instalar drenaje pleural y mantener antibiótico endovenoso

D Repetir la toracocentesis en 1 semana

E Cambiar a antibiótico oral y alta

Respuesta C. Un líquido pleural con pH menor a 7,2, glucosa menor a 40 mg/dL, LDH muy elevada o gérmenes en el Gram (o pus) corresponde a derrame paraneumónico complicado o empiema. Requiere drenaje pleural con tubo (eventualmente con fibrinolíticos o videotoracoscopía) además de antibiótico endovenoso. El neumococo es el agente más frecuente en niños.

▶ VER CLASE 2.01.4.011 Cultivos y antibiograma

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.13 · Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Cultivo identifica el agente y el antibiograma su susceptibilidad (sensible, intermedio, resistente; CIM); permite ajustar el antibiótico empírico.
- Urocultivo: positivo con ≥100.000 UFC/ml en segundo chorro, ≥10.000 (o ≥50.000) en sondeo y cualquier recuento en punción suprapúbica; bolsa recolectora solo sirve si es negativa. Polimicrobiano sugiere contaminación.
- Hemocultivos: tomar 2 muestras antes del antibiótico (1-3 ml en lactantes); S. coagulasa negativo en una sola muestra suele ser contaminante.
- Cultivo faríngeo para S. pyogenes (estándar), coprocultivo en disentería, cultivo de LCR y líquido articular; Gram orienta mientras llega el cultivo.
- Ajustar a espectro más estrecho según antibiograma (desescalar); no tratar colonización (ej. bacteriuria asintomática en niño sin síntomas).
- Patrones de resistencia: E. coli resistente a ampicilina y cotrimoxazol frecuente; SAMR adquirido en la comunidad (clindamicina, cotrimoxazol); BLEE requiere carbapenémico o según antibiograma.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 8 meses con fiebre de 39 °C sin foco tiene orina completa con leucocituria y nitritos positivos. El urocultivo, tomado por cateterismo vesical, informa Escherichia coli 50.000 UFC/mL, sensible a cefalosporinas de primera generación y resistente a ampicilina. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Contaminación, porque es menor a 100.000 UFC/mL

B Es necesario un hemocultivo para confirmar

C Bacteriuria asintomática que no requiere tratamiento

D Debe repetirse con bolsa recolectora

E Infección urinaria confirmada

Respuesta E. El punto de corte del urocultivo depende de la técnica: por punción suprapúbica cualquier recuento; por cateterismo vesical 10.000 UFC/mL o más (algunos usan 50.000); por segundo chorro 100.000 o más. Con fiebre, sedimento inflamatorio y 50.000 UFC/mL por cateterismo, la ITU está confirmada. El antibiograma permite ajustar el tratamiento, en este caso a cefalosporina.

▶ VER CLASE 2.01.4.012 Electrocardiograma

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.23 · Cardiología Pediátrica: Soplos, Insuficiencia Cardíaca, Arritmias, Endocarditis y Electrocardiograma

QUÉ HAY QUE SABER

- ECG pediátrico cambia con la edad: en RN predomina el ventrículo derecho (eje a la derecha +60 a +180°, onda R alta en V1, T positiva en V1 en la primera semana y luego negativa hasta la adolescencia).
- FC normal: RN 100-180 lpm, lactante 100-160, preescolar 80-120, escolar 70-110; arritmia sinusal respiratoria es normal.
- Taquicardia supraventricular: FC >220 en lactante o >180 en niño, QRS estrecho, RR fijo, sin P visible; taquicardia sinusal tiene P y variabilidad, FC <220.
- Indicaciones: síncope, palpitaciones, dolor torácico con ejercicio, soplo patológico, cardiopatía, trastornos electrolíticos, intoxicaciones, antes de metilfenidato si hay riesgo cardíaco.
- Hallazgos de riesgo: QT largo (QTc >460 ms), preexcitación (PR corto, onda delta: WPW), Brugada, bloqueo AV, hipertrofia ventricular.
- Electrolitos: hiperkalemia con T picudas y QRS ancho; hipokalemia con onda U; hipocalcemia con QT largo. Alterado: derivar a cardiología infantil.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un adolescente de 14 años consulta por episodios de palpitaciones de inicio y término brusco. Entre crisis, el electrocardiograma muestra intervalo PR corto, onda delta (empastamiento inicial del QRS) y QRS levemente ensanchado. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Bloqueo auriculoventricular de primer grado

B Síndrome de Wolff-Parkinson-White

C Síndrome de QT largo

D Hipertrofia ventricular izquierda

E Bloqueo completo de rama derecha

Respuesta B. PR corto con onda delta y QRS ancho es la preexcitación ventricular por una vía accesoria (síndrome de Wolff-Parkinson-White) que, junto a taquicardias paroxísticas, constituye una causa importante de taquicardia supraventricular en niños. Debe derivarse a cardiología para estratificación y eventual ablación, por riesgo de muerte súbita si se asocia a fibrilación auricular.

▶ VER CLASE 2.01.4.013 Electrolitos plasmáticos

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 2.3 · Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Valores normales: Na 135-145 mEq/L, K 3,5-5,5 mEq/L (más alto en RN), Cl 98-106 mEq/L, HCO3 22-26 mEq/L.
- Indicaciones: deshidratación moderada-grave o con fluidoterapia EV, vómitos persistentes, convulsiones, compromiso de conciencia, enfermedad renal, CAD, uso de diuréticos.
- Hiponatremia: SIADH (meningitis, neumonía, postoperatorio), pérdidas digestivas con aporte hipotónico, intoxicación hídrica; síntomas neurológicos si <125 o caída rápida.
- Hipernatremia: deshidratación con pérdida de agua libre, preparación concentrada de fórmula, diabetes insípida; corrección lenta (≤10-12 mEq/L/día).
- Hipokalemia: diarrea, vómitos (alcalosis), diuréticos, insulina; hiperkalemia: falla renal, hemólisis de la muestra (pseudohiperkalemia), hiperplasia suprarrenal congénita (con hiponatremia).
- Anión gap = Na - (Cl + HCO3): elevado en CAD, acidosis láctica, intoxicaciones; normal en diarrea y acidosis tubular. Corregir siempre en contexto clínico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 6 meses con diarrea de 4 días llega irritable, con piel pastosa y signos de deshidratación moderada. Los electrolitos plasmáticos muestran Na+ 162 mEq/L, K+ 3,8 mEq/L y Cl- 128 mEq/L. **¿Cuál es el principio más importante del tratamiento?**

A Corregir el sodio en 4 a 6 horas con suero glucosado al 5%

B Administrar bicarbonato de sodio

C Administrar furosemida

D Restringir completamente el aporte de agua

E Descenso lento del sodio, no más de 10 a 12 mEq/L por día, por riesgo de edema cerebral

Respuesta E. En la deshidratación hipernatrémica, las neuronas generan osmoles idiógenos para protegerse. Si el sodio baja rápidamente, entra agua a las células y se produce edema cerebral y convulsiones. Por ello la corrección debe ser lenta: descenso máximo de 10 a 12 mEq/L en 24 horas, reponiendo el déficit en 48 a 72 horas, con controles frecuentes de electrolitos.

▶ VER CLASE 2.01.4.014 Gases en sangre arterial

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.5 · Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Valores normales arteriales: pH 7,35-7,45, PaCO2 35-45 mmHg, HCO3 22-26 mEq/L, PaO2 80-100 mmHg (con aire ambiente), BE ±2.
- Interpretación ordenada: pH (acidemia/alcalemia), trastorno primario (PaCO2 respiratorio, HCO3 metabólico), compensación esperada y anión gap.
- Acidosis respiratoria: hipoventilación (agotamiento en asma o bronquiolitis, depresión del SNC, neuromuscular); PaCO2 normal o alta en crisis asmática grave es signo de agotamiento.
- Acidosis metabólica: diarrea (AG normal), shock, CAD, IRA (AG alto); alcalosis metabólica: vómitos, estenosis pilórica; alcalosis respiratoria: hiperventilación, ansiedad, inicio de crisis asmática.
- Insuficiencia respiratoria: PaO2 <60 mmHg (tipo I) o PaCO2 >50 mmHg con acidosis (tipo II).
- Gases venosos o capilares sirven para pH y PaCO2 (no PaO2); la saturometría monitoriza la oxigenación de forma no invasiva.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 10 meses con síndrome bronquial obstructivo lleva 3 horas en tratamiento con salbutamol y oxígeno. Está cada vez más somnoliento, con menor esfuerzo respiratorio y murmullo pulmonar disminuido. Los gases arteriales muestran pH 7,22, PaCO2 62 mmHg, HCO3- 24 mEq/L y PaO2 58 mmHg. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Acidosis respiratoria aguda con hipoxemia: falla respiratoria global

B Alcalosis respiratoria compensada

C Acidosis metabólica compensada

D Gases normales para la edad

E Alcalosis metabólica

Respuesta A. pH bajo con PaCO2 elevada y bicarbonato normal es acidosis respiratoria aguda (sin compensación renal). Junto con hipoxemia, somnolencia y menor esfuerzo, indica insuficiencia respiratoria global por agotamiento. En una obstrucción bronquial, una PaCO2 normal o alta es signo de gravedad. Requiere unidad de paciente crítico y probable soporte ventilatorio.

▶ VER CLASE 2.01.4.015 Hemograma

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.25 · Inmunodeficiencias Primarias, Infecciones Recurrentes, Hepatomegalia e Interpretación del Hemograma Pediátrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Valores varían con la edad: RN con Hb alta (14-22 g/dL) y leucocitosis; nadir fisiológico de Hb a los 2-3 meses (~9-11 g/dL); linfocitos predominan entre 1 mes y 4-5 años (fórmula invertida).
- Anemia: Hb <11 g/dL (6 m-5 años), <11,5 (5-11 años), <12 (12-14 años); VCM orienta: microcítica (ferropenia, talasemia), normocítica (hemólisis, pérdida aguda, ERC), macrocítica (déficit de B12/folato, hipotiroidismo, medicamentos).
- Reticulocitos altos: hemólisis o sangrado (regenerativa); bajos: falla medular o déficit de sustratos.
- Leucocitosis con neutrofilia y desviación a izquierda: infección bacteriana; linfocitosis con atípicos: VEB; linfocitosis marcada: coqueluche; eosinofilia: alergia, parásitos.
- Neutropenia: leve 1.000-1.500, moderada 500-1.000, grave <500/mm³; trombocitopenia <150.000 (PTI si aislada).
- Banderas rojas: bicitopenia o pancitopenia, blastos en frotis (leucemia), esquistocitos (SHU, microangiopatía): derivar urgente.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 14 meses, sano, tiene un hemograma solicitado en su control: hemoglobina 11,8 g/dL, leucocitos 10.500/mm3 con 30% de neutrófilos y 62% de linfocitos, y plaquetas 320.000/mm3. El frotis no muestra células anormales. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Sugiere leucemia linfática; derivar a hematología

B Hemograma normal para la edad

C Neutropenia grave que requiere estudio

D Infección viral que requiere tratamiento

E Anemia que requiere suplementar hierro

Respuesta B. En lactantes y preescolares predominan normalmente los linfocitos en la fórmula leucocitaria; esta inversión fisiológica se mantiene aproximadamente hasta los 4 a 6 años. Con 30% de neutrófilos de 10.500 leucocitos, el recuento absoluto (3.150/mm3) es normal. La hemoglobina es normal a esta edad (mayor a 11 g/dL), igual que las plaquetas.

▶ VER CLASE 2.01.4.016 Orina completa

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.13 · Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Orina completa: examen físico (color, densidad), químico (tira reactiva) y sedimento microscópico.
- ITU: leucocituria (>5-10 leucocitos/campo), nitritos positivos (alta especificidad, baja sensibilidad en lactantes que orinan seguido), bacteriuria; siempre confirmar con urocultivo bien tomado.
- Hematuria: ≥5 GR/campo; GR dismórficos y cilindros hemáticos sugieren origen glomerular (GNAPE, nefropatía IgA).
- Proteinuria: tira ≥1+ (30 mg/dL); cuantificar con índice proteinuria/creatininuria en muestra aislada (normal <0,2; nefrótico >2). Proteinuria ortostática benigna en adolescentes.
- Glucosuria: diabetes o tubulopatía; cetonuria: ayuno, CAD; densidad baja persistente: diabetes insípida, ERC.
- Muestra: segundo chorro con aseo genital; sondeo o punción suprapúbica en lactantes para urocultivo; procesar dentro de 1 h o refrigerar.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 7 meses, sin antecedentes, con fiebre de hasta 39 °C de 2 días de evolución, decaimiento e inapetencia, sin síntomas respiratorios ni digestivos. Examen físico reactivo, salvo por la fiebre. Se instala bolsa recolectora perineal: el sedimento muestra leucocitos y bacterias abundantes. **¿Cuál es la conducta más adecuada antes de iniciar el tratamiento antibiótico?**

A Iniciar cefadroxilo oral con el resultado de la bolsa recolectora

B Realizar sondeo vesical para tomar un urocultivo confirmatorio

C Esperar 48 horas sin tratamiento a que la bolsa confirme el diagnóstico

D Solicitar cintigrama DMSA de urgencia

E Dar el alta, porque la bolsa recolectora siempre contamina

Respuesta B. La bolsa recolectora tiene una tasa de falsos positivos demasiado alta para confirmar o tratar. Con un sedimento alterado, la norma exige confirmar con sondeo vesical o punción suprapúbica antes de iniciar antibióticos.

▶ VER CLASE 2.01.4.017 Parasitológico de deposiciones

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.1 · Diarrea Aguda y Crónica en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Parasitológico seriado de deposiciones (PSD): 3 muestras en días alternos en fijador (PAF); detecta quistes, huevos y trofozoítos de protozoos y helmintos.
- Indicaciones: diarrea prolongada o crónica, dolor abdominal recurrente, malabsorción, eosinofilia, anemia ferropriva sin causa, prurito anal.
- Hallazgos más frecuentes: Blastocystis hominis (patogenicidad discutida, tratar si sintomático), Giardia lamblia (metronidazol, tinidazol), Entamoeba histolytica, Cryptosporidium (inmunodeprimidos).
- Comensales no patógenos (Entamoeba coli, Endolimax nana) no requieren tratamiento, pero indican contaminación fecal-oral.
- Oxiuros no se detectan bien en PSD: usar test de Graham (cinta adhesiva perianal en la mañana antes del aseo, 3 días).
- Resultado negativo no descarta Giardia (excreción intermitente): considerar antígeno fecal; tratar a convivientes en oxiuros.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 4 años que asiste a jardín infantil presenta deposiciones blandas, malolientes y flotantes, distensión abdominal y meteorismo desde hace 4 semanas, con baja de peso leve. Hay casos similares en su sala. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico más probable?**

A Coprocultivo

B Test de Graham

C Parasitológico seriado de deposiciones (3 muestras)

D Rotavirus en deposiciones

E Colonoscopía

Respuesta C. Diarrea crónica malabsortiva (esteatorreica, maloliente) con meteorismo en un niño de jardín, con casos en su sala, sugiere giardiasis, la parasitosis intestinal más frecuente en Chile. Se diagnostica con parasitológico seriado de deposiciones (3 muestras en días alternos, por la excreción intermitente de quistes) o antígeno en deposiciones. Se trata con metronidazol, tinidazol o nitazoxanida.

▶ VER CLASE 2.01.4.018 Perfil bioquímico

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 7.19 · Déficit de Vitamina D, Osteomalacia del Adulto y Raquitismo

QUÉ HAY QUE SABER

- Perfil bioquímico incluye glicemia, BUN, creatinina, ácido úrico, calcio, fósforo, proteínas totales, albúmina, colesterol, bilirrubina, transaminasas, fosfatasas alcalinas, LDH.
- Particularidades pediátricas: fosfatasas alcalinas fisiológicamente altas en etapas de crecimiento (lactante, estirón puberal); fósforo más alto en niños; creatinina menor según masa muscular.
- Calcio bajo: hipoparatiroidismo, déficit de vitamina D (raquitismo: fosfatasas muy altas, fósforo bajo), hipoalbuminemia (corregir); calcio alto: inmovilización, hiperparatiroidismo, neoplasias.
- Albúmina baja: síndrome nefrótico, desnutrición, enteropatía perdedora de proteínas, falla hepática.
- LDH y ácido úrico elevados: hemólisis, leucemia/linfoma, lisis tumoral.
- Interpretar en contexto clínico con valores de referencia por edad; alteraciones inesperadas: repetir y estudiar causa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 14 meses, de piel oscura, con lactancia materna exclusiva prolongada sin suplementación de vitamina D, presenta piernas arqueadas, ensanchamiento de muñecas y rosario costal. **¿Qué alteración del perfil bioquímico es la más esperable?**

A Fosfatasa alcalina baja y fósforo alto

B Todas las pruebas normales

C Calcio muy elevado y PTH baja

D Fosfatasa alcalina elevada, fósforo bajo y calcio normal o bajo

E Fosfatasa alcalina normal y fósforo alto

Respuesta D. El raquitismo carencial por déficit de vitamina D produce menor absorción de calcio, hiperparatiroidismo secundario con fosfaturia y, por ello, hipofosfemia con calcio normal o bajo. La fosfatasa alcalina se eleva marcadamente por el aumento de actividad osteoblástica, y es el marcador más útil. La 25-OH vitamina D está baja.

▶ VER CLASE 2.01.4.019 Perfil lipídico

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 5.4 · Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

QUÉ HAY QUE SABER

- Perfil lipídico: colesterol total, HDL, triglicéridos y LDL calculado (Friedewald si TG <400); idealmente en ayuno de 9-12 h.
- Valores aceptables en niños: CT <170 mg/dL, LDL <110, no-HDL <120, TG <75 (0-9 años) y <90 (10-19 años), HDL >45.
- Limítrofe: CT 170-199, LDL 110-129; alto: CT ≥200, LDL ≥130, TG ≥100 (<10 años) o ≥130 (10-19 años); HDL bajo <40.
- Indicaciones: tamizaje universal a los 9-11 años y 17-21 años; selectivo desde los 2 años con historia familiar de hipercolesterolemia o ECV precoz, obesidad, DM, HTA, ERC, síndrome nefrótico.
- LDL ≥190 mg/dL o ≥160 con historia familiar: sospechar hipercolesterolemia familiar (estudiar a la familia).
- Confirmar con 2 muestras separadas 2-12 semanas; descartar causas secundarias (hipotiroidismo, obesidad, nefrótico, fármacos) antes de iniciar manejo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En el control de salud de un niño de 5 años, sano y con IMC normal, la madre refiere que el padre del niño tuvo un infarto agudo al miocardio a los 45 años y tiene colesterol total de 320 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A No solicitar exámenes hasta los 18 años

B Solicitar solo glicemia

C Iniciar estatina empírica

D Solicitar perfil lipídico en ayunas

E Solicitar perfil lipídico solo si desarrolla obesidad

Respuesta D. Se recomienda tamizaje selectivo con perfil lipídico desde los 2 años en niños con antecedente familiar de enfermedad cardiovascular precoz (hombres menores de 55 años, mujeres menores de 65) o dislipidemia familiar, además de un tamizaje universal entre los 9 y 11 años. Así se pesquisa la hipercolesterolemia familiar, que requiere manejo precoz. Las estatinas no se usan sin diagnóstico.

▶ VER CLASE 2.01.4.020 Proteína C reactiva cuantitativa

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.9 · Síndrome Febril Agudo sin Foco en el Lactante: Estratificación según Edad, Criterios de Rochester y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- PCR: reactante de fase aguda sintetizado en el hígado; sube a las 6-8 h del estímulo, peak a las 48 h; vida media corta (19 h) lo que permite seguir la respuesta al tratamiento.
- Valores: normal <1 mg/dL (<10 mg/L); PCR >8-10 mg/dL sugiere infección bacteriana (neumonía bacteriana, pielonefritis, bacteriemia), sin ser diagnóstica.
- Útil en lactantes febriles sin foco para estratificar riesgo de infección bacteriana grave (junto con hemograma y procalcitonina) y en sospecha de artritis séptica u osteomielitis.
- Limitaciones: puede ser normal en infección muy precoz (<12 h) y elevarse en virus como adenovirus, influenza, enfermedad de Kawasaki, trauma, cirugía y enfermedades inflamatorias.
- PCR seriada: útil en sepsis neonatal (dos PCR normales a las 24-48 h ayudan a suspender antibióticos) y para monitorizar osteomielitis.
- No reemplaza la evaluación clínica: no tratar un número sin contexto.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 4 meses presenta fiebre de 39 °C de 3 horas de evolución, sin foco al examen. Está en buenas condiciones. Se solicita hemograma, orina completa y proteína C reactiva, que resulta 0,6 mg/dL. **¿Cuál es la interpretación más adecuada de la PCR?**

A Descarta infección bacteriana grave

B Permite dar el alta sin control

C Confirma una infección viral

D Indica que no se requiere orina completa

E Puede estar aún normal por el poco tiempo de evolución de la fiebre

Respuesta E. La proteína C reactiva se eleva entre 6 y 12 horas tras el inicio del proceso inflamatorio y alcanza su máximo a las 36 a 48 horas. Con fiebre de menos de 6 a 12 horas puede ser normal aun en una infección bacteriana grave. Debe interpretarse con la clínica y la evolución; la procalcitonina sube más precozmente.

▶ VER CLASE 2.01.4.021 Pruebas de coagulación

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Hematología** 8.11 · Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno

QUÉ HAY QUE SABER

- Pruebas básicas: recuento de plaquetas, tiempo de protrombina (TP/INR, vía extrínseca: VII), TTPA (vía intrínseca: VIII, IX, XI, XII) y fibrinógeno.
- TTPA prolongado aislado: hemofilia A (VIII) o B (IX), von Willebrand (a veces), heparina, anticoagulante lúpico; mezclar con plasma normal: corrige en déficit de factores, no corrige con inhibidores.
- TP prolongado: déficit de vitamina K (enfermedad hemorrágica del RN si no recibió vitamina K, malabsorción, colestasia), daño hepático, anticoagulantes orales; corrige con vitamina K si es por déficit.
- TP y TTPA prolongados con plaquetas y fibrinógeno bajos y dímero D alto: coagulación intravascular diseminada (sepsis, meningococcemia).
- Plaquetas bajas con TP y TTPA normales: PTI, leucemia, SHU (esquistocitos); sangrado mucocutáneo con estudio normal: von Willebrand (estudio de factor y antígeno) o disfunción plaquetaria.
- Indicaciones: sangrado anormal, antes de cirugía con historia sugerente, sospecha de CID, hepatopatía; derivar a hematología si estudio alterado.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 3 años con equimosis fáciles tiene recuento de plaquetas normal, TP normal y TTPA prolongado. Se realiza una prueba de mezcla con plasma normal y el TTPA se corrige completamente. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Presencia de un inhibidor (anticoagulante lúpico o anticuerpo contra un factor)

B Déficit de un factor de la vía intrínseca (ej. VIII, IX o XI)

C Déficit de factor VII

D Trombocitopenia inmune

E Coagulación intravascular diseminada

Respuesta B. El TTPA evalúa la vía intrínseca (XII, XI, IX, VIII) y común; el TP la vía extrínseca (VII) y común. Si el TTPA prolongado se corrige al mezclar con plasma normal, falta un factor (el plasma normal lo aporta): en un niño con sangrado sugiere hemofilia A o B, y se dosifican factores VIII y IX.

▶ VER CLASE 2.01.4.022 Pruebas de función renal

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Nefrología** 5.1 · Enfermedad Renal Crónica (KDIGO) y Garantías Explícitas en Salud (GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Creatinina sérica refleja la función renal pero varía con masa muscular y edad (más baja en niños); en RN refleja inicialmente la creatinina materna.
- Estimar VFG con fórmula de Schwartz modificada: VFG = 0,413 × talla (cm) / creatinina (mg/dL); normal >90 ml/min/1,73 m² desde los 2 años (menor en lactantes).
- BUN aumenta en deshidratación, hemorragia digestiva, catabolismo; relación BUN/creatinina >20 sugiere causa prerrenal.
- Lesión renal aguda: aumento de creatinina ≥1,5 veces basal o ≥0,3 mg/dL en 48 h, o diuresis <0,5 ml/kg/h; FENa <1% prerrenal y >2% renal (NTA).
- Complementar con orina completa, índice proteinuria/creatininuria, electrolitos y gases (acidosis), ecografía renal; cistatina C útil cuando la masa muscular es baja.
- VFG <60 por >3 meses o alteraciones persistentes: ERC, derivar a nefrología pediátrica; ajustar dosis de fármacos según VFG.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 8 años, con talla de 125 cm, tiene creatinina plasmática de 0,9 mg/dL. Se quiere estimar su velocidad de filtración glomerular. **¿Qué método es el más adecuado para estimarla en pediatría?**

A Fórmula de Schwartz (talla y creatinina)

B Fórmula de Cockcroft-Gault

C Ecuación CKD-EPI

D Solo el nitrógeno ureico

E La creatinina sola, comparada con valores del adulto

Respuesta A. En niños, la filtración glomerular se estima con la fórmula de Schwartz modificada: VFG = 0,413 × talla (cm) / creatinina (mg/dL). En este caso, 0,413 × 125 / 0,9 = 57 mL/min/1,73 m2, es decir, disminuida. Las fórmulas del adulto (CKD-EPI, Cockcroft-Gault) no son válidas en niños, y la creatinina normal varía con la edad y la masa muscular.

▶ VER CLASE 2.01.4.023 Pruebas hepáticas

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.17 · Ictericia Neonatal: Fisiológica vs Patológica (< 24 h), Incompatibilidad ABO/Rh, Curvas Bhutani y Fototerapia

QUÉ HAY QUE SABER

- Daño hepatocelular: transaminasas (ALT más específica de hígado; AST también en músculo y glóbulos rojos); >10 veces lo normal en hepatitis viral aguda, isquemia, tóxicos (paracetamol).
- Colestasia: bilirrubina directa >1 mg/dL (o >20% si bilirrubina total >5), GGT y fosfatasas alcalinas elevadas; en lactante con acolia sospechar atresia de vías biliares (urgencia).
- Función hepática real: TP/INR (no corrige con vitamina K en falla hepática), albúmina, glicemia y amonio.
- Hiperbilirrubinemia indirecta: ictericia neonatal fisiológica, hemólisis (reticulocitos, LDH, Coombs), Gilbert (adolescente con ictericia leve en ayuno o enfermedad, sin hemólisis).
- Fosfatasas alcalinas aisladas elevadas en crecimiento son fisiológicas; CK elevada con transaminasas altas sugiere miopatía (distrofia de Duchenne).
- Transaminasas elevadas en niño obeso: hígado graso; persistentes sin causa: estudiar celiaquía, Wilson, autoinmune, virus; derivar a gastroenterología si falla hepática o colestasia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 5 semanas, de término, presenta ictericia desde la segunda semana de vida, deposiciones de color blanco masilla (acolia) y orinas oscuras. Está con buen incremento ponderal. Al examen tiene hepatomegalia firme. Exámenes: bilirrubina total 8 mg/dL con directa 6 mg/dL y GGT elevada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Fototerapia

B Suspender la lactancia materna por 48 horas

C Derivación urgente para estudio de atresia de vías biliares

D Control en 1 mes

E Exanguinotransfusión

Respuesta C. Una bilirrubina directa elevada (mayor a 1 mg/dL o 20% del total) es colestasia y nunca es fisiológica; con acolia, coluria y GGT alta sugiere atresia de vías biliares. Requiere derivación urgente, porque la portoenteroestomía de Kasai rinde mejor antes de los 45 a 60 días de vida.

▶ VER CLASE 2.01.4.024 Pruebas tiroideas

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Endocrinología** 1.4 · Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito

QUÉ HAY QUE SABER

- TSH es el mejor examen de tamizaje de función tiroidea; complementar con T4 libre.
- TSH alta + T4 libre baja: hipotiroidismo primario (congénito o Hashimoto); TSH alta + T4 libre normal: hipotiroidismo subclínico (repetir; tratar si TSH >10).
- TSH baja + T4 libre alta: hipertiroidismo (enfermedad de Graves; anticuerpos anti receptor de TSH); TSH baja/normal + T4 libre baja: hipotiroidismo central (hipofisario).
- Tamizaje neonatal con TSH en sangre de talón (40 h-7 días); TSH elevada: confirmar con TSH y T4 libre en sangre venosa y tratar de inmediato con levotiroxina.
- Valores de TSH en RN son fisiológicamente altos en las primeras 24-48 h (pico post parto); no interpretar antes.
- Anticuerpos antiperoxidasa (antiTPO) y antitiroglobulina apoyan tiroiditis autoinmune; indicaciones: talla baja, bocio, obesidad con baja velocidad de crecimiento, síndrome de Down, DM1.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

El programa de tamizaje neonatal informa que un recién nacido de 7 días tiene TSH elevada en la muestra de sangre en papel filtro. Está asintomático. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Repetir el tamizaje en papel filtro a los 2 meses

B Solicitar cintigrafía tiroidea antes de cualquier tratamiento

C Esperar la aparición de síntomas para tratar

D Citar de inmediato para confirmar con TSH y T4 libre en sangre venosa e iniciar levotiroxina sin esperar síntomas

E Iniciar propiltiouracilo

Respuesta D. El hipotiroidismo congénito suele ser asintomático al nacer y es una causa prevenible de discapacidad intelectual. Ante un tamizaje alterado se confirma de inmediato con TSH y T4 libre séricas y, si se confirma, se inicia levotiroxina idealmente antes de los 15 días de vida. Los estudios etiológicos (ecografía, cintigrafía) no deben retrasar el tratamiento.

▶ VER CLASE 2.01.4.025 Serología y técnicas de aislamiento viral y bacteriano

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.5 · Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico microbiológico: detección directa del agente (cultivo, antígenos, PCR) o respuesta inmune (serología IgM/IgG).
- Virus respiratorios: inmunofluorescencia o PCR de hisopado/aspirado nasofaríngeo (VRS, influenza, adenovirus, parainfluenza, metapneumovirus, SARS-CoV-2); útil en hospitalizados para cohortear y en influenza para indicar oseltamivir.
- Coqueluche: PCR para Bordetella pertussis en hisopado nasofaríngeo (mayor rendimiento en las primeras 3 semanas).
- Serología: IgM indica infección aguda (VHA, VEB VCA-IgM, Mycoplasma, toxoplasma); IgG indica infección pasada o inmunidad; seroconversión o alza de 4 veces el título confirma. Anticuerpos maternos persisten hasta 18 meses en lactantes (VIH: usar PCR).
- Test rápido de antígeno para S. pyogenes en faringe (alta especificidad) y rotavirus en deposiciones.
- Interpretar en contexto clínico: PCR positiva puede reflejar portación o excreción prolongada (adenovirus, rinovirus).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 3 meses, en época invernal, presenta coriza, tos y luego dificultad respiratoria con sibilancias y crepitaciones difusas. Se hospitaliza y se desea identificar el agente viral para cohortear a los pacientes. **¿Cuál es el examen más adecuado?**

A Serología IgM para virus respiratorios

B Inmunofluorescencia o PCR viral en aspirado o hisopado nasofaríngeo

C Hemocultivo

D Cultivo de expectoración

E Recuento de eosinófilos

Respuesta B. El diagnóstico etiológico de las infecciones respiratorias virales agudas se realiza con detección de antígenos (inmunofluorescencia) o PCR en muestra nasofaríngea, rápida y sensible. En la bronquiolitis el agente más frecuente es el virus respiratorio sincicial. La serología es tardía y poco útil en infecciones agudas; el hemocultivo y el cultivo de expectoración son para bacterias.

▶ VER CLASE 2.01.4.026 **Test del sudor** NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 4.5 · Hemoptisis y Bronquiectasias

QUÉ HAY QUE SABER

- Test del sudor: estimulación con pilocarpina (iontoforesis) y medición de cloro en sudor; examen diagnóstico de fibrosis quística.
- Interpretación: cloro ≥60 mmol/L positivo (en 2 muestras confirma FQ); 30-59 mmol/L intermedio (repetir y estudio genético); <30 mmol/L normal.
- Indicaciones: infecciones respiratorias recurrentes o SBO persistente, neumonías a repetición, bronquiectasias, desnutrición con esteatorrea, íleo meconial, prolapso rectal, pólipos nasales, deshidratación con alcalosis hipoclorémica, hermano con FQ, tamizaje neonatal positivo (tripsina inmunorreactiva).
- Requisitos: niño >2 semanas y >2 kg, cantidad suficiente de sudor (≥75 mg o 15 µl); falsos positivos con desnutrición, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal; falsos negativos con edema.
- Confirmación con estudio genético de mutaciones CFTR (ΔF508 la más frecuente).
- Resultado positivo: derivar a centro de FQ (GES).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 2 años presenta neumonías y bronquitis obstructivas a repetición, tos productiva crónica, deposiciones abundantes, grasosas y malolientes, y mal incremento ponderal pese a buen apetito. Su madre nota que su piel es muy salada al besarlo. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?**

A Cuantificación de inmunoglobulinas

B Espirometría

C TAC de tórax

D Anticuerpos antitransglutaminasa

E Test del sudor (cloro en sudor)

Respuesta E. Infecciones respiratorias recurrentes con tos productiva, esteatorrea por insuficiencia pancreática, falla de crecimiento y piel salada sugieren fibrosis quística. El examen de elección es el test del sudor por iontoforesis con pilocarpina: cloro en sudor de 60 mmol/L o más en dos muestras confirma; entre 30 y 59 es limítrofe y requiere estudio genético del gen CFTR.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

12 códigos

▶ VER CLASE 2.01.5.001 **Antropometría en la edad pediátrica** NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.1 · Evaluación del Crecimiento & Estado Nutricional en Pediatría: Curvas OMS (P/E, T/E, P/T)

QUÉ HAY QUE SABER

- Peso: balanza calibrada; lactante desnudo en pesa de bandeja, niño mayor con ropa interior de pie en balanza.
- Longitud en <2 años acostado en podómetro (infantómetro) con 2 personas, cabeza en plano de Frankfurt y piernas extendidas; talla de pie con estadiómetro desde los 2 años (talla de pie es ~0,7 cm menor).
- Perímetro craneano con cinta inextensible sobre glabela y protuberancia occipital (máximo diámetro), en cada control hasta los 2-3 años.
- Perímetro de cintura sobre el borde superior de la cresta ilíaca al final de la espiración, desde los 5-6 años para evaluar obesidad abdominal (≥p90).
- Registrar en curvas OMS según sexo y edad (corregida en prematuros hasta los 2 años) y calcular indicadores: P/E, T/E, P/T, IMC/E.
- Errores frecuentes: equipo no calibrado, ropa o pañal puesto, mala posición; interpretar la tendencia en controles sucesivos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 20 meses acude a su control de salud. La interna lo mide de pie en el estadiómetro, porque el niño ya camina, y registra su estatura en la curva de Talla para la Edad de la OMS. **¿Cuál es la corrección más adecuada a esta técnica?**

A Ninguna: desde que camina se mide de pie

B Medirlo acostado recién desde los 3 años

C Medirlo de pie, pero restar 2 cm al valor obtenido

D Medir solo el perímetro cefálico, que reemplaza a la talla en esta edad

E Medirlo acostado con infantómetro, porque hasta los 2 años se registra la longitud

Respuesta E. Hasta los 2 años se mide al niño acostado con infantómetro (longitud); desde los 2 años cumplidos, de pie con estadiómetro (estatura). Que el niño camine no cambia la técnica, y las curvas OMS están construidas así.

▶ VER CLASE 2.01.5.002 Atención inmediata del recién nacido

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.15 · Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

QUÉ HAY QUE SABER

- Preparación: anamnesis perinatal (edad gestacional, líquido amniótico, factores de riesgo de infección), equipo de reanimación listo, cuna radiante encendida.
- Evaluación inicial: ¿término?, ¿respira o llora?, ¿buen tono? Si todo es sí: contacto piel a piel con la madre, secado, cubrir y clampeo tardío del cordón (≥30-60 s).
- Apgar al minuto y a los 5 minutos (FC, esfuerzo respiratorio, tono, irritabilidad refleja, color); no se usa para decidir reanimación.
- Procedimientos: vitamina K 1 mg IM (0,5 mg en <1.500 g), profilaxis ocular (eritromicina o cloranfenicol), identificación, antropometría, examen físico (malformaciones, permeabilidad anal y esofágica si hay polihidroamnios).
- Lactancia materna en la primera hora; BCG y hepatitis B antes del alta; tamizaje de TSH y PKU, auditivo y cardiopatías (saturometría) según protocolo.
- No se recomienda aspiración rutinaria de secreciones en RN vigoroso.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 50

Recién nacido de término por parto vaginal, con líquido amniótico claro. Al nacer llora inmediatamente, con frecuencia cardíaca de 145 latidos por minuto, buen tono muscular y piel rosada. **¿Cuál es la primera maniobra que realizas?**

A Aspiración rutinaria de vías aéreas

B Contacto piel a piel con la madre

C Vitamina K intramuscular

D Profilaxis ocular con eritromicina

E Oxígeno suplementario

Respuesta B. Con las tres preguntas iniciales en sí (término, buen tono, llanto vigoroso), no se aspira de rutina ni se separa al recién nacido: la primera prioridad es el apego piel a piel precoz.

▶ VER CLASE 2.01.5.003 Cateterismo vesical

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.13 · Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: obtención de orina estéril para urocultivo en niño sin control de esfínteres, retención urinaria aguda, medición de diuresis en paciente crítico, uretrocistografía.
- Técnica estéril: lavado genital, guantes estériles, campo estéril, lubricación; en niñas separar labios y visualizar meato; en niños, retraer suavemente el prepucio sin forzar.
- Calibre: 5-6 Fr en lactantes pequeños, 8 Fr en niños, aumentar según edad.
- Descartar los primeros mililitros y recolectar en frasco estéril; urocultivo positivo con ≥10.000 UFC/ml (algunas guías ≥50.000).
- Contraindicaciones: trauma uretral (sangre en meato, hematoma perineal), infección uretral activa; en fimosis estrecha preferir punción suprapúbica.
- Complicaciones: trauma uretral, falsa vía, infección; en retención urinaria, vaciar y evaluar causa.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 9 meses, sin control de esfínteres, presenta fiebre de 39 °C sin foco. Se decide estudiar una posible infección urinaria. **¿Cuál es el método más adecuado para obtener la muestra de urocultivo?**

A Cateterismo vesical con técnica estéril

B Bolsa recolectora adhesiva

C Recolección del pañal

D Segundo chorro espontáneo

E Orina de 24 horas

Respuesta A. En niños sin control de esfínteres, el urocultivo debe tomarse por cateterismo vesical estéril (o punción suprapúbica), porque la bolsa recolectora tiene una alta tasa de contaminación: solo es útil si resulta negativa. El segundo chorro se usa en niños con control miccional. La técnica requiere aseo genital, sonda fina y desechar las primeras gotas.

▶ VER CLASE 2.01.5.004 Maniobra de Heimlich

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.8 · Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: obstrucción completa de vía aérea por cuerpo extraño en niño consciente >1 año (no puede toser, hablar ni llorar, cianosis); si tose efectivamente, estimular la tos y no intervenir.
- Técnica (>1 año): colocarse detrás del niño, puño sobre la línea media del abdomen entre ombligo y xifoides, y compresiones abdominales rápidas hacia adentro y arriba hasta expulsar el objeto o pérdida de conciencia.
- Lactante <1 año: no compresiones abdominales (riesgo de lesión hepática); alternar 5 golpes interescapulares en decúbito prono con cabeza más baja y 5 compresiones torácicas en supino.
- Si pierde la conciencia: iniciar RCP comenzando con compresiones; al abrir vía aérea mirar la boca y retirar el objeto solo si es visible (no barrido digital a ciegas).
- En obesos o embarazadas: compresiones torácicas en lugar de abdominales.
- Después de la maniobra derivar a evaluación médica (posibles lesiones internas o cuerpo extraño residual: broncoscopía).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 73

Un niño de 7 años, mientras estaba comiendo, presenta agitación súbita, asociada a imposibilidad de respirar. No puede toser, hablar ni llorar. **¿Cuál es la maniobra más adecuada en este momento?**

A Realizar respiración boca a boca

B Meterle los dedos en la boca y retirar el cuerpo extraño

C Dar golpes en la región interescapular

D Abrazarlo por detrás y realizar compresiones subxifoideas

E Realizar compresiones en el pecho, en decúbito supino

Respuesta D. Obstrucción completa de la vía aérea por cuerpo extraño en un niño consciente mayor de 1 año: maniobra de Heimlich, con compresiones abdominales subxifoideas desde atrás. Los golpes interescapulares con compresiones torácicas son para el menor de 1 año, y el barrido a ciegas está contraindicado.

▶ VER CLASE 2.01.5.005 Osteoclisis

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.11 · Diarrea Aguda Infantil y Planes de Rehidratación Oral OMS (Plan A, B, C) y Síndrome Hemolítico Urémico

QUÉ HAY QUE SABER

- Osteoclisis (acceso intraóseo): vía de emergencia cuando no se obtiene acceso venoso en 60-90 segundos en paro cardiorrespiratorio, shock o estatus convulsivo.
- Sitio de elección en niños: tibia proximal, cara anteromedial 1-3 cm bajo la tuberosidad tibial; alternativas tibia distal (sobre maléolo medial), fémur distal, húmero proximal en mayores.
- Técnica: asepsia, aguja intraósea manual o dispositivo de taladro (EZ-IO), insertar perpendicular o en ángulo alejándose del cartílago de crecimiento hasta perder resistencia; confirmar con aspiración de médula y paso libre de suero sin extravasación.
- Permite administrar todos los fármacos, fluidos y hemoderivados con efecto similar a la vía venosa; usar bolos con presión.
- Contraindicaciones: fractura en el hueso elegido, intento previo en el mismo hueso, infección local, osteogénesis imperfecta.
- Complicaciones: extravasación y síndrome compartimental, osteomielitis; retirar en <24 h una vez obtenido acceso venoso.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 108

Un lactante de 4 meses presenta una diarrea grave y abundante, asociada a deterioro del estado general y sopor. Sus exámenes muestran elevación de la creatinina, hiponatremia e hipokalemia. Ha sido imposible encontrar una vía venosa periférica para administrar fluidos. **¿Cuál es el medio de hidratación más adecuado?**

A Catéter femoral
B Catéter subclavio
C Denudación de safena
D Vía intraósea
E Sonda nasogástrica

Respuesta D. Un lactante con deshidratación grave y compromiso de conciencia (plan C) requiere reposición endovenosa inmediata. Si no se logra una vía periférica rápidamente (ej. 90 segundos o 3 intentos), la vía de elección en pediatría es la intraósea (osteoclisis), habitualmente en la tibia proximal, por la que se pueden pasar fluidos y fármacos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 136

Un lactante de 1 años de vida ingresa al servicio de urgencia en malas condiciones generales, soporoso, con extremidades pálidas y frías en la zona distal. Se indica hidratación endovenosa, pero, a pesar de intentarlo, es imposible acceder a un vía venosa. ¿Cuál es la vía de elección para admninistrar fluidos en este paciente?

A Catéter venoso central
B Línea arterial
C Sonda nasogástrica
D Denudación venosa
E Osteoclisis

Respuesta E. En los niños, al fallar la vía venosa, se prefiere la osteoclisis. En los adultos, la denudacion venosa.

▶ VER CLASE 2.01.5.006 Oxigenoterapia

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.5 · Bronquiolitis Aguda & Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO): VRS, Score de Tal y Manejo Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: hipoxemia (saturación <90-93% según condición) en bronquiolitis, neumonía, crisis asmática, insuficiencia respiratoria, shock, paro; meta saturación ≥93% (90-95% en prematuros para evitar retinopatía).
- Sistemas de bajo flujo: naricera (cánula nasal) 0,5-2 L/min en lactantes, hasta 4 L/min en niños (FiO2 24-40%); mascarilla simple 5-10 L/min (FiO2 35-50%).
- Alto requerimiento: mascarilla con reservorio 10-15 L/min (FiO2 60-90%); cánula nasal de alto flujo humidificada (1-2 L/kg/min) en bronquiolitis moderada-grave.
- Humidificar con flujos altos; monitorizar saturometría y signos de dificultad respiratoria.
- Hipoxemia que no corrige o hipercapnia: escalar a VNI o ventilación mecánica.
- Oxígeno domiciliario (POD) en displasia broncopulmonar u otras enfermedades crónicas según protocolo; precauciones: no fumar ni fuego cerca.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 4 meses con bronquiolitis de 3 días de evolución. Al examen: FR 62 rpm, tiraje subcostal e intercostal, sibilancias espiratorias y saturación de 89% con aire ambiental. Está alerta y se alimenta con dificultad. **Respecto del oxígeno, ¿cuál es la indicación más adecuada?**

A No indicar oxígeno hasta que la saturación baje de 85%
B Nebulizar salbutamol con aire comprimido en vez de oxígeno
C Oxígeno al 100% con mascarilla con reservorio para lograr saturación de 100%
D Intubación y ventilación mecánica inmediatas
E Oxígeno por naricera de bajo flujo, ajustado para mantener saturación de 93% o más

Respuesta E. Una saturación bajo 93% en un lactante con bronquiolitis es criterio de hospitalización y de oxigenoterapia. Se usa naricera de bajo flujo, titulada para saturar 93% o más. No se busca saturar 100% y el niño está alerta, sin criterio de ventilación mecánica.

▶ VER CLASE 2.01.5.007 Proctoclisis

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Gastroenterología** 6.2 · Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Proctoclisis: administración de líquidos por vía rectal (enema evacuante) para desimpactación fecal en constipación con fecaloma.
- Indicaciones: impactación fecal (masa fecal palpable en abdomen o tacto rectal) cuando no se usa desimpactación oral con PEG en dosis altas; preparación para procedimientos.
- Soluciones: suero fisiológico tibio 5-10 ml/kg o enemas comerciales; evitar enemas de fosfato en <2 años y en insuficiencia renal (hiperfosfemia, hipocalcemia); no usar agua corriente (intoxicación hídrica).
- Técnica: decúbito lateral izquierdo con rodillas flectadas, sonda rectal lubricada, introducir lentamente, retener algunos minutos.
- Contraindicaciones: sospecha de abdomen agudo, obstrucción intestinal, ECN, neutropenia, trauma rectal, cirugía reciente.

- Tras desimpactar, iniciar mantención con laxante osmótico (PEG o lactulosa) y hábito defecatorio.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un niño de 5 años con constipación crónica presenta dolor abdominal y escurrimiento fecal. Al examen se palpa masa fecal en hipogastrio y el tacto rectal confirma impactación fecal. Se planifica desimpactación con proctoclisis (enema). **¿En cuál de las siguientes situaciones está contraindicada la proctoclisis?**

A Constipación funcional con fecaloma

B Escurrimiento fecal (encopresis por rebalse)

C Neutropenia grave por quimioterapia

D Antecedente de fisura anal cicatrizada

E Dieta pobre en fibra

Respuesta C. La desimpactación fecal puede hacerse con polietilenglicol oral en dosis altas o por vía rectal (proctoclisis o enemas). La manipulación rectal está contraindicada en pacientes neutropénicos o inmunosuprimidos (riesgo de bacteriemia), con sospecha de abdomen agudo u obstrucción, enterocolitis o cirugía colorrectal reciente. El escurrimiento por rebalse es justamente una indicación de desimpactar.

▶ VER CLASE 2.01.5.008 Punción lumbar

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.14 · Convulsiones Febriles: Crisis Simple vs Compleja, Punción Lumbar & Pronóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: sospecha de meningitis o encefalitis (fiebre con meningismo, lactante febril <28 días o con mal aspecto), convulsión febril con signos meníngeos o <12 meses con vacunas incompletas o antibiótico previo, hemorragia subaracnoidea con TC negativa.
- Contraindicaciones: hipertensión endocraneana o focalidad (TC previa), inestabilidad hemodinámica o respiratoria, coagulopatía o plaquetas <50.000, infección en el sitio de punción; no retrasar antibióticos por la PL.
- Técnica: posición sentada o decúbito lateral con flexión máxima, sin comprometer la ventilación en lactantes; espacio L3-L4 o L4-L5 (la médula termina en L2-L3 en lactantes); asepsia y aguja con mandril.
- Muestras: citoquímico (células, glucosa con glicemia simultánea, proteínas), Gram, cultivo, PCR; presión de apertura si es posible.
- LCR bacteriano: >1.000 células PMN, glucosa baja, proteínas altas; viral: pleocitosis mononuclear con glucosa normal.
- Complicaciones: cefalea post punción, punción traumática, infección, herniación si hay hipertensión endocraneana no detectada.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Lactante de 11 meses, con vacunas al día, con otitis media aguda en tratamiento con amoxicilina desde hace 3 días. Hoy, con fiebre de 39 °C, presenta una crisis tónico-clónica generalizada de 2 minutos que cede sola. A los 30 minutos está algo irritable, sin rigidez de nuca ni focalidad, con fontanela normotensa. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Alta con antipiréticos y educación, porque es una convulsión febril simple

B Realizar punción lumbar, porque venía recibiendo antibióticos

C Solicitar electroencefalograma urgente

D Iniciar fenobarbital de mantención

E Realizar TAC de cerebro y dar el alta si es normal

Respuesta B. En un lactante con convulsión febril, el tratamiento antibiótico previo puede enmascarar una meningitis decapitada: es indicación de punción lumbar, igual que los signos meníngeos, la letargia persistente o las vacunas incompletas. El EEG y la neuroimagen no están indicados de rutina.

▶ VER CLASE 2.01.5.009 Punción pleural

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Respiratorio** 3.2 · Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: derrame pleural paraneumónico significativo (>1 cm en decúbito lateral) para diagnóstico, derrame que compromete la respiración, sospecha de empiema.
- Técnica: asepsia, anestesia local, paciente sentado; punción en línea axilar media o posterior en 5º-7º espacio intercostal (o guiada por ecografía), por el borde superior de la costilla inferior (evitar paquete vasculonervioso).
- Muestras: pH, glucosa, LDH, proteínas, recuento celular, Gram y cultivo; contrastar con valores séricos (criterios de Light).
- Derrame complicado o empiema (pus, pH <7,2, glucosa <40 mg/dL, LDH >1.000, Gram/cultivo positivo): tubo de drenaje pleural ± fibrinolíticos o videotoracoscopía.
- Contraindicaciones relativas: coagulopatía, plaquetas bajas, infección cutánea en el sitio.
- Complicaciones: neumotórax (Rx de control), hemotórax, lesión hepática o esplénica, edema pulmonar por reexpansión si se evacúa gran volumen rápidamente.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Se realizará una punción pleural diagnóstica en un niño de 7 años con derrame pleural paraneumónico moderado, sentado e inclinado hacia adelante, con ecografía que marca el sitio de punción. **¿Cuál es la técnica correcta para introducir la aguja?**

A Por el borde superior de la costilla inferior

B Por el borde inferior de la costilla superior

C Por el centro del espacio intercostal, sin referencia costal

D En la línea medioclavicular, segundo espacio intercostal

E Por debajo de la décima costilla posterior

Respuesta A. El paquete vasculonervioso intercostal (vena, arteria y nervio) discurre por el borde inferior de cada costilla. Por eso la aguja se introduce rasando el borde superior de la costilla inferior, en la línea axilar media o posterior, idealmente guiada por ecografía. El segundo espacio en la línea medioclavicular se usa para descomprimir un neumotórax a tensión, no para derrames.

▶ VER CLASE 2.01.5.010 Punción suprapúbica

NIVEL **DERIVAR A ESPECIALISTA**

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.13 · Infección del Tracto Urinario (ITU) en Pediatría: ITU Febril, Estudio por Imágenes & Profilaxis

QUÉ HAY QUE SABER

- Punción suprapúbica: método de referencia para obtener orina estéril en lactantes sin control de esfínteres; cualquier recuento bacteriano en el urocultivo es significativo.
- Indicaciones: lactantes <1-2 años cuando el sondeo es imposible o poco confiable (fimosis estrecha, sinequia vulvar, malformaciones), necesidad de muestra no contaminada.
- Requisitos: vejiga llena (no haber orinado en 1 h; idealmente confirmar con ecografía), asepsia, punción 1-2 cm sobre la sínfisis púbica en la línea media, perpendicular o con leve inclinación cefálica.
- Contraindicaciones: vejiga vacía, distensión abdominal, malformaciones o cirugía abdominal baja, coagulopatía, infección cutánea local.
- Complicaciones (raras): hematuria microscópica transitoria, perforación intestinal, infección.
- Según el perfil, su realización se deriva a especialista; el médico general debe conocer indicaciones e interpretar el urocultivo obtenido.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un lactante de 2 meses con fiebre sin foco requiere urocultivo. No fue posible realizar cateterismo vesical por fimosis estrecha, por lo que se obtiene la muestra mediante punción suprapúbica, que informa Escherichia coli 2.000 UFC/mL. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A Contaminación, porque el recuento es bajo

B Bacteriuria asintomática

C Requiere repetir con bolsa recolectora

D Infección urinaria confirmada, ya que por punción suprapúbica cualquier recuento es significativo

E Se necesitan más de 100.000 UFC/mL para confirmar

Respuesta D. La punción suprapúbica obtiene orina directamente de la vejiga, normalmente estéril, por lo que cualquier recuento de bacterias gramnegativas es significativo. Se indica en lactantes cuando no es posible el cateterismo (fimosis estrecha, sinequias), preferentemente guiada por ecografía con vejiga llena. Los puntos de corte de mayor recuento son para cateterismo y segundo chorro.

▶ VER CLASE 2.01.5.011 Reanimación neonatal

NIVEL **REALIZAR**

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.15 · Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

QUÉ HAY QUE SABER

- Pasos iniciales (primeros 30 s): mantener temperatura (cuna radiante, secar, gorro; bolsa plástica en <32 semanas), posicionar vía aérea, aspirar solo si hay obstrucción, estimular.
- Si apnea, respiración boqueante o FC <100 lpm: ventilación a presión positiva (VPP) en el primer minuto (minuto de oro) con bolsa-mascarilla a 40-60 respiraciones/min; es la intervención más importante.
- Iniciar con aire ambiente (FiO2 21%) en ≥35 semanas y 21-30% en prematuros; ajustar según saturación preductal (mano derecha) objetivo por minuto de vida; monitor de saturación y ECG.
- Si VPP no es efectiva: corregir (MR SOPA: mascarilla, reposicionar, succionar, abrir boca, presión, vía aérea alternativa).
- FC <60 lpm tras 30 s de VPP efectiva: intubar y compresiones torácicas (técnica de 2 pulgares, tercio inferior del esternón) relación 3:1 (90 compresiones + 30 ventilaciones/min) con FiO2 100%.
- FC <60 pese a compresiones: adrenalina 0,01-0,03 mg/kg EV (vena umbilical) o 0,05-0,1 mg/kg endotraqueal; considerar expansión con SF 10 ml/kg si hipovolemia.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 59

Recién nacido de término que nace deprimido, con apnea y una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. Se estimula, se administra oxígeno y se inician ventilaciones a presión positiva. Al reevaluar a los 30 segundos, la frecuencia cardíaca se mantiene en el mismo valor. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Administrar adrenalina por vía endovenosa

B Realizar intubación orotraqueal

C Continuar con ventilación a presión positiva y reevaluar en 30 segundos

D Aumentar la presión de ventilación y reevaluar en 30 segundos

E Iniciar compresiones torácicas

Respuesta E. Tras 30 segundos de VPP efectiva, la frecuencia cardíaca sigue bajo 60: corresponde agregar masaje cardíaco coordinado con la ventilación.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 57

Recién nacido por cesárea de urgencia, por un registro fetal con signos de hipoxia. Al examen tiene cianosis generalizada e hipotonía, sin esfuerzo respiratorio; se seca y se pone bajo calor radiante, en posición de olfateo, con aporte de oxígeno. A los 50 segundos persiste en apnea y el pulso carotídeo es de 30 latidos por minuto. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?**

A Conectar a ventilación mecánica

B Administrar bicarbonato endovenoso

C Administrar adrenalina por vía orotraqueal

D Dar ventilación a presión positiva con mascarilla facial

E Realizar masaje cardíaco

Respuesta D. Tras los pasos iniciales, un recién nacido en apnea con bradicardia grave requiere primero ventilación a presión positiva; el masaje cardíaco solo se agrega si la frecuencia sigue bajo 60 pese a la VPP efectiva.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Parto vaginal de una primigesta de 39 semanas. El recién nacido nace con llanto débil y tono flácido. Se traslada a cuna de calor radiante: se seca, se posiciona la cabeza en olfateo y se estimula. Al minuto de vida: continúa en apnea, no llora, y la auscultación muestra una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto. **¿Cuál es la conducta inmediata?**

A Iniciar compresiones torácicas en relación 3:1

B Iniciar ventilación a presión positiva con aire ambiental

C Administrar adrenalina por vena umbilical

D Dar oxígeno libre en flujo continuo al 100%

E Calcular el Apgar y esperar al minuto 5 para intervenir

Respuesta B. Al minuto de vida, apnea y frecuencia cardíaca bajo 100 obligan a iniciar ventilación a presión positiva de inmediato. En un recién nacido de término se inicia con aire ambiental. El masaje y la adrenalina no tienen indicación todavía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 151

Una paciente de 26 años, cursando un embarazo de 41 semanas, inicia trabajo de parto. Al examen tienen 4 contracciones cada 10 minutos, dilatación cervical de 6 cm El registro fetal muestra desaceleraciones variables. Al romperse las membranas sale meconio espeso. El nacimiento se produce algunos minutos después, obteniéndose un recién nacido hiporreactivo e hipotónico. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A Poner bajo calor radiante, administrar oxígeno, secar y reevaluar en 30 segundos

B Realizar intubación orotraqueal y aspirar la vía aérea

C Realizar ventilación a presión positiva

D Realizar compresiones torácicas

E Aspirar el contenido gástrico

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar intubación orotraqueal y aspirar la vía aérea (opción B).

▶ VER CLASE 2.01.5.012 Reanimación cardiopulmonar pediátrica

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.24 · Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica, Intoxicaciones y Prevención de Accidentes

QUÉ HAY QUE SABER

- Cadena de supervivencia pediátrica: prevención, RCP precoz de calidad, activación del sistema de emergencia, soporte vital avanzado y cuidados post paro.
- Secuencia C-A-B: verificar respuesta, pedir ayuda y DEA, evaluar respiración y pulso (≤10 s); sin pulso o FC <60 con mala perfusión: iniciar compresiones.
- Compresiones: 100-120/min, profundidad 1/3 del tórax (4 cm lactante con 2 dedos o 2 pulgares; 5 cm niño con 1-2 manos), reexpansión completa, mínimas interrupciones. Relación 30:2 un reanimador, 15:2 dos reanimadores; con vía aérea avanzada 1 ventilación c/2-3 s.
- Si el reanimador está solo y no presenció el colapso: 2 minutos de RCP antes de ir a buscar ayuda (paro por asfixia); colapso súbito presenciado: activar emergencia y buscar DEA primero.
- DEA con parches pediátricos en <8 años (o adultos si no hay); FV/TV sin pulso: desfibrilar 2 J/kg, luego 4 J/kg; adrenalina 0,01 mg/kg EV/IO c/3-5 min; amiodarona 5 mg/kg en ritmos desfibrilables refractarios.
- Buscar causas reversibles (H y T) y tras recuperar circulación evitar hipoxemia, hiperoxia, hipotensión e hipertermia; trasladar a UCI pediátrica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Usted y un colega encuentran a un lactante de 6 meses que no responde, no respira y no tiene pulso braquial. Inician la reanimación cardiopulmonar. **¿Cuál es la relación compresiones-ventilaciones y la técnica de compresión recomendada para dos reanimadores?**

A 30:2 con el talón de una mano sobre el esternón

B 15:2 con técnica de dos pulgares y manos rodeando el tórax, comprimiendo un tercio del diámetro anteroposterior

C 5:1 con dos dedos

D 3:1 como en el recién nacido

E Solo compresiones, sin ventilaciones

Respuesta B. En RCP pediátrica, con un reanimador la relación es 30:2; con dos reanimadores, 15:2. En lactantes se prefiere la técnica de dos pulgares con manos rodeando el tórax (con dos reanimadores), comprimiendo al menos un tercio del diámetro anteroposterior (unos 4 cm), a 100 a 120 por minuto. La relación 3:1 es para la reanimación neonatal en sala de partos.

20

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

91 CÓDIGOS

360 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Situaciones clínicas	32
Situaciones clínicas de urgencia	21
Conocimientos generales	16
Exámenes e imagenología	8
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	14

Situaciones clínicas

32 códigos

▶ VER CLASE **3.01.1.001** **Aborto espontáneo** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.10 · Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030

QUÉ HAY QUE SABER

- Metrorragia del 1.er trimestre con o sin dolor cólico: primero tacto vaginal (OCI abierto o cerrado), luego ecografía transvaginal; siempre beta-hCG y hemodinamia.
- OCI cerrado: embrión con latidos = amenaza de aborto; embrión ≥7 mm sin latidos o saco sin embrión = aborto retenido; cavidad vacía con endometrio fino = aborto completo.
- OCI abierto con restos en la cavidad = aborto incompleto (o en evolución); saco intrauterino descarta el ectópico en la práctica.
- Manejo inicial: amenaza → reposo relativo y control; retenido/incompleto <12 semanas estable → misoprostol 800 µg vaginal o sublingual, o AMEU (preferible al legrado: menos perforación y sinequias).
- Rh negativo no sensibilizada: inmunoglobulina anti-D dentro de 72 h. Banderas rojas: shock hipovolémico (vías gruesas y evacuar), fiebre con flujo fétido (aborto séptico).
- Seguimiento: derivar a ginecología; estudio de aborto recurrente desde 3 pérdidas consecutivas.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 68

Mujer de 28 años con antecedente de 3 abortos espontáneos en primer trimestre y episodio de sangrado vaginal profuso durante el embarazo actual. **¿Cuál es el estudio más adecuado para investigar la causa?**

A Panel de trombofilias (anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina, anti-β2-glicoproteína I)

B Cariotipo de los padres

C Histeroscopia diagnóstica

D Progesterona en fase lútea

E TSH y T4 libre

Respuesta A. Abortos recurrentes del primer trimestre: se debe descartar síndrome antifosfolípido con anticoagulante lúpico, anticardiolipina y anti-β2-glicoproteína I. Es la causa tratable más importante.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 97

Paciente de 21 años consulta por fiebre hasta 38,9 grados, dolor hipogástrico intenso y sangrado vaginal de mal olor, iniciado hace 48 horas. Tiene frecuencia cardíaca de 120, presión arterial de 90/60 y temperatura de 38,7 grados. En la especuloscopía se observan sangre y restos ovulares de mal olor. El útero está muy doloroso a la palpación. La ecografía transvaginal muestra contenido uterino irregular de 18 milímetros. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar histerectomía

B Realizar laparoscopía exploradora

C Administrar antibióticos endovenosos y realizar evacuación uterina

D Administrar metotrexato

E Administrar misoprostol y conducir el trabajo de aborto

Respuesta C. Fiebre, taquicardia, restos ovulares de mal olor y útero muy doloroso: aborto séptico con restos retenidos. Se cubre primero con antibióticos endovenosos de amplio espectro y luego se evacúa la cavidad con AMEU o legrado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 20

Paciente de 32 años, cursando un embarazo de 6 semanas por amenorrea, consulta por metrorragia de un día de evolución, sin otros síntomas. En la especuloscopía se observa salida de sangre por el orificio cervical externo. La ecografía transvaginal muestra un saco gestacional colapsado a nivel del istmo. La subunidad beta de gonadotrofina coriónica resulta 5.500 unidades internacionales por litro. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Aborto retenido

B Amenaza de aborto

C Aborto incompleto

D Embarazo ectópico

E Mola hidatiforme

Respuesta C. La visualización de un saco gestacional dentro del útero descarta el embarazo ectópico. Un saco colapsado, migrando hacia el cuello, con beta-hCG que ya no corresponde a un embarazo en curso, define el aborto incompleto.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 26 años, con 8 semanas por fecha de última regla, consulta por metrorragia escasa de 2 días y dolor cólico leve. Al tacto vaginal el orificio cervical interno está cerrado. La ecografía transvaginal muestra un embrión de 9 milímetros, sin latidos cardíacos visibles. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?**

A Amenaza de aborto; reposo relativo y control ambulatorio

B Aborto retenido; ofrecer misoprostol o AMEU

C Aborto incompleto; realizar AMEU de urgencia

D Embarazo ectópico; solicitar beta-hCG cuantitativa

E Aborto completo; solo observación

Respuesta B. Embrión de 9 milímetros sin latidos, con cuello cerrado, cumple el criterio ecográfico de no viabilidad (7 milímetros o más sin actividad cardíaca): es un aborto retenido. Se ofrece misoprostol o AMEU, según la preferencia de la paciente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 159

Una paciente de 25 años, con antecedente de atraso menstrual de 6 semanas, consulta por metrorragia. Su test de embarazo es positivo. Su especuloscopía confirma metrorragia que proviene del orificio cervical y su tacto vaginal muestra un cuello cerrado, duro y de ubicación posterior. Se solicita una ecografía obstétrica que muestra lo siguiente: FOTO (Ecografía obstétrica con un saco gestacional de 11mm). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Dar misoprostol

B Realizar legrado

C Controlar con nueva ecografía en 7 días

D Realizar laparoscopía

E Dar metotrexato

Respuesta C. Tiene una amenaza de aborto, sin modificaciones cervicales, por lo que hay que observar. Además, la ecografía era normal, ya que el saco gestacional era menor a 18mm. Se controla con una EcoTV en 7 días, o antes, si empeoran los síntomas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 168

Una paciente, primigesta, presenta 4 semanas de atraso menstrual, por lo que se realiza test de embarazo, que resulta positivo. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra un saco gestacional intrauterino, con un embrión de 3 mm, sin latidos. La beta-HCG resulta 6.800 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Repetir la beta-HCG en 48 horas

B Indicar metotrexato

C Realizar nueva ecografía en 7 días

D Realizar legrado en 14 días

E Realizar legrado inmediatamente

Respuesta C. Para diagnosticar un aborto retenido, se necesita que el embrión tenga más de 5 mm. Como tiene 3, se debe controlar en 7 a 10 días, con una nueva Eco. Si continúa sin latidos, se puede legar u observar por 2 semanas, a espera de que inicie espontáneamente el trabajo de aborto (si no inicia, se legra).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 61

Una paciente de 23 años, con antecedente de 2 abortos previos de primer trimestr

E Actualmente cursa un nuevo embarazo de 8 semanas, siendo diagnosticada de aborto retenido, mediante ecografía transvaginal. ¿Cuál es el estudio inicial para esta paciente?

A Histerosalpingografía

B Cariograma al padre y a la madre

C Histeroscopía

D Estudio de trombofilia

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Histeroscopía). Las lesiones de extremidades inferiores más importantes son la fractura de fémur, la fractura de pierna y la fractura de tobillo.

▶ VER CLASE 3.01.1.002 **Anemia y embarazo** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.1 · Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre

QUÉ HAY QUE SABER

- Anemia en el embarazo: Hb <11 g/dL en 1.er y 3.er trimestre (<10,5 g/dL en el 2.º); la hemodilución fisiológica baja la Hb pero no bajo esos cortes.
- La causa más frecuente es ferropénica: microcitosis (VCM <80 fL) y ferritina baja (<15–30 ng/mL); hemograma en el primer control y repetir a las 28 semanas.
- Profilaxis: hierro 30–60 mg/día desde las 16–20 semanas; ácido fólico 0,4–1 mg/día preconcepcional hasta las 12 semanas (4–5 mg si alto riesgo de DTN).
- Tratamiento: hierro oral elemental 100–200 mg/día (ej. sulfato ferroso) lejos de comidas, con vitamina C; control de Hb y reticulocitos en 2–4 semanas.
- Hierro endovenoso si hay intolerancia, malabsorción o falta de respuesta; transfusión solo en anemia grave sintomática o hemorragia.
- Macrocítica: sospechar déficit de B12 (veganas) o folato. Seguimiento: no requiere derivación; el médico controla la respuesta hasta normalizar Hb y depósitos.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 53

Embarazada de 20 semanas, asintomática, con hemoglobina de 9,0 g/dL, VCM de 72 fL (microcítica) y ferritina de 8 ng/mL. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A Hierro oral elemental 200 mg/día
B Transfusión de glóbulos rojos
C Hierro endovenoso
D Vitamina B12 intramuscular
E Ácido fólico

Respuesta A. Anemia ferropénica del embarazo (Hb bajo 11 g/dL, microcitosis y ferritina baja) en paciente asintomática: el tratamiento de primera línea es hierro oral en dosis terapéutica. El hierro endovenoso se reserva para intolerancia, malabsorción o falta de respuesta; la transfusión, para anemia grave sintomática o hemorragia.

▶ VER CLASE 3.01.1.003 **Colestasia gravídica** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.8 · Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico

QUÉ HAY QUE SABER

- Colestasia intrahepática del embarazo: prurito palmoplantar de predominio nocturno en el 3.er trimestre, que luego se generaliza, sin lesiones primarias (solo escoriaciones).
- Ictericia en 10–15%, posterior al prurito; transaminasas elevadas en 60–80%. Confirma y estratifica: ácidos biliares séricos totales (≥10 µmol/L).
- Diferencial: hígado graso agudo (falla hepática, hipoglicemia), HELLP (plaquetopenia, HTA), hepatitis viral, erupción polimorfa (con pápulas y placas).
- Tratamiento inicial: ácido ursodesoxicólico 10–15 mg/kg/día VO en 2–3 tomas; antihistamínico para el prurito.
- Riesgo: muerte fetal súbita (arritmia o vasoespasmo) que el monitoreo no predice; la prevención es la interrupción programada según ácidos biliares (≥100 µmol/L: 34–36 semanas; en general 37 semanas).
- Seguimiento: derivar a alto riesgo obstétrico; recurre en embarazos siguientes y con anticonceptivos con estrógenos.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 46

Paciente de 34 años, con embarazo de 32 semanas, inicia prurito de palmas y plantas más intenso en la noche, asociado a astenia y vómitos. Leve ictericia de escleras, sin lesiones cutáneas. Bilirrubina 1,5 mg/dL, fosfatasas alcalinas 411 UI/L, GGT 398 UI/L. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Colestasia intrahepática
B Colangitis biliar primaria
C Ictericia por hiperémesis gravídica
D Hígado graso agudo del embarazo
E Coledocolitiasis

Respuesta A. Prurito palmoplantar nocturno sin lesiones primarias, con patrón colestásico de laboratorio, en el tercer trimestre, es el cuadro clásico de CIE. El diagnóstico es clínico; los ácidos biliares complementan la sospecha.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

¿Por qué motivo la monitorización fetal electrónica anteparto habitual, el registro basal no estresante semanal, no es suficiente para garantizar la seguridad fetal en una colestasia intrahepática severa? **¿Cuál es la explicación correcta?**

A Porque los ácidos biliares impiden la transmisión de las ondas Doppler
B Porque la muerte fetal en CIE ocurre por un evento súbito de arritmia o vasoespasmo, sin hipoxia crónica previa
C Porque todos los fetos con CIE presentan taquicardia basal fija irreversible
D Porque la colestasia solo afecta a la madre y el feto nunca tiene complicaciones
E Porque el ácido ursodesoxicólico altera artificialmente el trazado cardiofetal

Respuesta B. A diferencia de la insuficiencia placentaria crónica que sí se detecta con monitoreo, en la CIE el óbito ocurre de forma aguda e impredecible por toxicidad directa de los ácidos biliares sobre el miocardio fetal. Por eso la única estrategia eficaz es la interrupción programada.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Multigesta de 34 semanas, con prurito de 10 días que empeora en la noche, iniciado en palmas y plantas y extendido a antebrazos y abdomen. Sin erupciones ni lesiones primarias, solo escoriaciones de rascado. Escleras anictéricas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar ácido ursodesoxicólico y solicitar ácidos biliares séricos
B Indicar clobetasol tópico y biopsia cutánea
C Solicitar serología viral hepática antes de tratar
D Indicar permetrina al 5% por sospecha de escabiosis
E Interrumpir el embarazo de inmediato, sin más estudio

Respuesta A. El prurito palmoplantar nocturno sin lesiones primarias en el tercer trimestre es diagnóstico clínico de CIE. La conducta es iniciar UDCA y confirmar con ácidos biliares, que además estratifican la severidad y el momento del parto.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 85

Una paciente de 25 años, con 33 semanas de embarazo, consulta por prurito de predominio palmo-plantar, pero que en ocasiones es generalizado. Refiere que es más intenso en la noche. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A Transaminasas
B Ecografía abdominal
C Ácidos biliares
D Fosfatasas alcalinas
E Bilirrubina total y diferenciada

Respuesta D. El diagnóstico de la colestasia intrahepática es clínico y no requiere de exámenes. Sin embargo, las fosfatasas alcalinas se elevan con mucha frecuencia, mientras que la bilirrubina puede ser normal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 153

Mujer cursando embarazo de 37 semanas, consulta por prurito palmo-plantar. En los exámenes destacan ácidos biliares de 110- 112, conducta:

A Interrupción del embarazo
B Ácido ursoderxecolico
C Antihistamínicos 154. Paciente con sd nefrotico y hipergammaglobulinemia policlonal, complemento bajo. Diagnóstico:
A Lupus
B Amiloidosis

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Interrupción del embarazo (opción A).

▶ VER CLASE 3.01.1.004 **Diabetes y embarazo**

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Diabetes 1.3 · Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)
Diabetes 2.4 · Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante
Obstetricia 19.7 · Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia

QUÉ HAY QUE SABER

- Glicemia de ayuno en el 1.er control: <100 normal; 100–125 repetir y si se confirma = diabetes gestacional precoz; ≥126 (o ≥200 al azar) = diabetes pregestacional.
- Si la basal es normal: PTGO 75 g a las 24–28 semanas a todas; glicemia a las 2 h ≥140 mg/dL = diabetes gestacional (139 es normal).
- Riesgos: la pregestacional mal controlada causa malformaciones (cardiopatías, regresión caudal, DTN); la gestacional típica no malforma, pero da macrosomía, distocia de hombros e hipoglicemia neonatal.
- Manejo inicial: dieta fraccionada (4 comidas y 2 colaciones), actividad física y automonitoreo; metas: ayuno <95 (ideal 70–90), 1 h postprandial <140, 2 h <120 mg/dL.
- Insulina (NPH ± rápida) si >20% de controles fuera de meta tras 1–2 semanas de dieta; metformina no es primera línea (cruza la placenta). Suspender antidiabéticos orales y pasar a insulina en la pregestacional.
- Seguimiento: derivar a policlínico de alto riesgo obstétrico; reclasificar con PTGO 6–12 semanas posparto (alto riesgo futuro de DM2).

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 9

Una paciente embarazada de 32 semanas, con altura uterina: 38 cm e IMC: 33 se realiza una ecografía obstétrica, que muestra feto creciendo en percentil 93, con ILA: 12. Se solicita test de tolerancia a la glucosa oral, que resulta 92 mg/dl basal y 170 mg/dl a las dos horas postcarga de glucosa. **¿Cuál es la causa más probable de la condición fetal?**

A Diabetes mellitus gestacional
B Obesidad materna
C Diabetes mellitus pregestacional
D Incompatibilidad de grupo Rh
E Síndrome hipertensivo del embarazo

Respuesta A. Feto grande para la edad gestacional (sobre p90) con prueba de tolerancia alterada en el tercer trimestre: macrosomía por diabetes gestacional. La hiperglicemia materna provoca hiperinsulinismo fetal, que actúa como hormona de crecimiento.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 60

Mujer de 35 años, con embarazo de 15 semanas, sin síntomas. En exámenes de control destaca VDRL negativo, hemoglobina de 11,5 mg/dL y glicemia de ayuno de 108 mg/dL. Examen físico normal, con altura uterina acorde. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este caso?**

A Solicitar test de tolerancia oral a la glucosa

B Indicar dieta y mantener el control habitual

C Solicitar hemoglobina glicosilada

D Indicar insulina subcutánea

E Solicitar una nueva glicemia de ayunas

Respuesta E. Glicemia de ayuno entre 100 y 125 mg/dL: se repite el examen, no se salta a la prueba de tolerancia ni se trata todavía. La PTGO se reserva para las 24 a 28 semanas, salvo que la segunda glicemia confirme la diabetes gestacional precoz.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 38

Paciente de 31 años, con embarazo de 28 semanas, se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, que resulta 75 mg/dL basal y 160 mg/dL a las 2 horas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Intolerancia a la glucosa

B Diabetes gestacional

C Diabetes pregestacional

D Diabetes mellitus 2

E Resistencia a la insulina

Respuesta B. La glicemia a las 2 horas de 160 mg/dL, sobre el corte de 140, define diabetes gestacional. No es pregestacional, porque esa se diagnostica con glicemias de ayuno de 126 mg/dL o más, y esta paciente ya está en el segundo trimestre.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 73

Paciente de 37 años, con embarazo de 29 semanas, se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa de 75 gramos, con glicemia basal de 86 mg/dL y postcarga de 139 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar dieta hipoglucídica y controlar con glicemias seriadas

B Solicitar hemoglobina glicosilada

C Iniciar metformina

D Repetir el examen a las 32 semanas

E Mantener el control habitual del embarazo

Respuesta E. La glicemia a las 2 horas de 139 mg/dL queda justo bajo el corte de 140 mg/dL: el resultado es normal y no requiere dieta especial ni fármacos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 9

Una paciente embarazada de 32 semanas, con altura uterina de 38 cm e IMC de 33, se realiza una ecografía obstétrica que muestra feto creciendo en percentil 93, con ILA de 12. Se solicita test de tolerancia a la glucosa oral, que resulta 92 mg/dl basal y 170 mg/dl a las dos horas postcarga de glucosa. **¿Cuál es la causa más probable de la condición fetal?**

A Diabetes mellitus gestacional

B Obesidad materna

C Diabetes mellitus pregestacional

D Incompatibilidad de grupo Rh

E Síndrome hipertensivo del embarazo

Respuesta A. Feto grande para la edad gestacional (percentil sobre 90) con PTGO de 2 horas ≥ 140 mg/dL: diabetes gestacional. La hiperglicemia materna produce hiperinsulinismo fetal y macrosomía. No es pregestacional, porque se diagnostica tarde y con valores bajo los de no embarazada.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Secundigesta de 26 semanas, con IMC de 28. Su glicemia en ayunas del primer trimestre fue 88 mg/dL. La PTGO a las 25 semanas muestra: basal 92 mg/dL y 2 horas post-carga 158 mg/dL. Está asintomática. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Control habitual, ya que la glicemia basal es normal

B Iniciar insulina NPH de inmediato

C Terapia nutricional fraccionada y automonitoreo glucémico

D Iniciar metformina 850 mg cada 12 horas

E Repetir la prueba de tolerancia en 4 semanas

Respuesta C. La glicemia a las 2 horas de 158 mg/dL, sobre el corte de 140, ya es diagnóstica de diabetes gestacional. El primer paso es terapia nutricional y automonitoreo, reevaluando en 1 a 2 semanas antes de considerar insulina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 23

Embarazada de 8 semanas consulta por exámenes. Se realiza PTGO 75g: glicemia ayuno 88 mg/dL y a las 2 horas 140 mg/dL. ¿Cómo se interpreta este resultado?

A Resistencia a la insulina

B Normal para el embarazo

C Diabetes pregestacional

D Diabetes gestacional

E Intolerancia a la glucosa gestacional

Respuesta B. PTGO en embarazo (ADA/OMS): diagnóstico de DG requiere glicemia ayuno ≥92, 1h ≥180 o 2h ≥153 mg/dL. Con 2h en 140 mg/dL (< 153), el resultado es NORMAL. Se realiza nueva PTGO a las 24-28 semanas si el riesgo persiste.

▶ VER CLASE 3.01.1.005 Embarazo con edad gestacional dudosa

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.2 · Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)

QUÉ HAY QUE SABER

- Edad gestacional dudosa: FUM no recordada o no confiable (ciclos irregulares, uso de ACO o lactancia en los 3 meses previos, metrorragia del 1.er trimestre).
- El método más preciso es la ecografía precoz: longitud céfalo-nalgas entre 7 y 14 semanas (error ±3–5 días); el saco gestacional, la hCG y la altura uterina no sirven para datar.
- Si FUM y LCN difieren >5–7 días se corrige por la ecografía y esa pasa a ser la fecha oficial; si difieren menos, se mantiene la FUM.
- En el 2.º trimestre: diámetro biparietal, circunferencia craneana y fémur (error ±1–2 semanas); el cerebelo transverso es útil si se sospecha RCF. En el 3.er trimestre la datación es poco confiable (±3 semanas).
- Conducta inicial: solicitar ecografía lo antes posible y no recalcular la EG con ecografías posteriores. Seguimiento: derivar a alto riesgo si la ecografía es tardía, por el riesgo de mal diagnóstico de RCF o postérmino.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 98

Mujer con reglas irregulares y test de embarazo positivo. Recuerda la fecha de su última regla (FUR), pero por sus ciclos irregulares esta no es confiable. Tiene una amenorrea de 10 semanas. **¿Cómo se debe determinar la edad gestacional?**

A Longitud céfalo-caudal

B Diámetro del saco gestacional

C Niveles de β-hCG

D Según la FUR

E Interrupción del embarazo

Respuesta A. Cuando la FUR no es confiable, la edad gestacional se establece por ecografía precoz. Entre las 7 y 14 semanas, la longitud céfalo-caudal (LCC) es el parámetro más exacto, con error de unos 5 a 7 días. El saco gestacional es menos preciso y la β-hCG no sirve para datar.

▶ VER CLASE 3.01.1.006 Embarazo ectópico no complicado

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.11 · Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: dolor pélvico, atraso menstrual y metrorragia escasa con test de embarazo positivo; 95% tubárico (ampular el más frecuente).
- Factores de riesgo: ectópico previo (x5–10), PIP o salpingitis, cirugía tubaria, DIU, tabaquismo, fertilización asistida.
- Zona discriminatoria: beta-hCG ≥1.500–2.000 UI/L con útero vacío en la ecografía transvaginal = ectópico; bajo ese valor, repetir hCG en 48 h (el embarazo normal la duplica).
- Primera evaluación: hemodinamia y signos peritoneales; si está estable, derivar a urgencia gineco-obstétrica para confirmar y tratar.
- Metotrexato IM en dosis única si cumple todo: estable, hCG <5.000, masa <3,5 cm y sin latidos; si no, laparoscopía (salpingostomía si desea fertilidad, salpingectomía si no). Rh(–): anti-D.
- Seguimiento: derivar; control de hCG los días 4 y 7 tras metotrexato (descenso ≥15%) y luego semanal hasta negativizar.

PREGUNTAS · 12

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 29

Una paciente de 24 años presenta amenorrea de 7 semanas de evolución, por lo que consulta. Su examen físico muestra frecuencia cardíaca de 80 por minuto, presión arterial de 120/80 mmHg, sin alteraciones en su examen ginecológico. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?**

A Subunidad beta HCG

B Niveles plasmáticos de FSH

C Ecografía transvaginal

D Niveles plasmáticos de prolactina

E Niveles plasmáticos de TSH

Respuesta A. El estudio de la amenorrea debe comenzar siempre descartando el embarazo con beta hCG, incluso si la paciente ya tuvo un test previo negativo, antes de continuar con TSH, prolactina y FSH.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 29

Mujer de 24 años con amenorrea de 7 semanas. Su examen físico es normal. La beta-hCG plasmática resulta 4.000 unidades por litro, y la ecografía transvaginal muestra una masa anexial derecha de 3 centímetros, sin líquido libre. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Repetir los niveles de hCG en 48 horas

B Realizar salpingostomía por laparotomía

C Realizar salpingectomía por vía laparoscópica

D Indicar metotrexato por vía intramuscular

E Controlar con una ecografía en 10 días

Respuesta D. Beta-hCG sobre la zona discriminatoria con útero vacío confirma el ectópico. Cumple los tres criterios de metotrexato: hCG menor de cinco mil, masa menor de 3,5 centímetros, sin latidos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 149

Mujer de 25 años, con atraso menstrual de 3 semanas y dolor abdominal de 5 días, mayor en la fosa ilíaca izquierda. La beta-hCG resulta 5.500 unidades por litro. La ecografía transvaginal muestra útero sin gestación intrauterina y un tumor anexial izquierdo de 53 milímetros, de aspecto complejo, sin líquido libre. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar laparoscopía exploradora

B Realizar laparotomía exploradora

C Indicar metotrexato

D Solicitar ecografía en 7 días

E Solicitar niveles de hCG y ecografía en 48 horas

Respuesta A. La masa mide más de 3,5 centímetros y la beta-hCG supera las cinco mil unidades: no cumple los criterios de metotrexato. Al no estar rota, la vía es laparoscópica, no la laparotomía.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 29 años, con 7 semanas de amenorrea, consulta por dolor leve en fosa ilíaca derecha. Está hemodinámicamente estable. La beta-hCG cuantitativa es 3.200 unidades por litro, y la ecografía transvaginal muestra útero vacío con una masa anexial derecha de 2,4 centímetros, sin latidos cardíacos y sin líquido libre. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Salpingectomía laparoscópica de urgencia

B Metotrexato intramuscular a dosis única

C Manejo expectante sin ningún control

D Laparotomía exploradora inmediata

E Repetir la beta-hCG en 4 semanas

Respuesta B. Estable, beta-hCG bajo cinco mil, masa menor de 3,5 centímetros y sin latidos: cumple los tres criterios de metotrexato. La cirugía se reserva para cuando falla alguno de esos criterios o hay rotura.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 55

Una paciente de 27 años presenta amenorrea de 7 semanas, por lo que se realiza un test de embarazo en orina, el que resulta positivo. Acude a control, solicitándose subunidad beta-HCG, que resulta 970 U/L y ecografía transvaginal, que muestra útero con endometrio de características normales, sin presencia de saco gestacional y visualización de un tumor anexial de 2,5 cm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar laparoscopía

B Repetir la subunidad beta en 48 horas

C Iniciar metotrexato

D Repetir la ecografía en 48 horas

E Repetir la ecografía en 7 a 10 días

Respuesta B. Embarazo ectópico vs. Embarazo normal: Se sospecha de un embarazo ectópico cuando una prueba de embarazo es positiva pero no se visualiza el saco gestacional en la ecografía. Para confirmar el diagnóstico, se debe analizar la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana (hCG). Si la concentración es mayor a 3500 U/L, se confirma el embarazo ectópico. Si es menor a 3500 U/L, se debe repetir la prueba en 48 horas. Es importante tener en cuenta que un tumor anexial detectado en la ecografía...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 130

Una paciente de 35 años con antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica previa tratada, consulta por un cuadro de 24 horas de evolución de sangrado genital escaso y dolor abdominal bajo asociado a un test de embarazo en orina positivo. Refiere 6 semanas de amenorrea. Al examen físico sus signos vitales muestran FC: 82x', PA: 110/74 mmHg y se encuentra en buenas condiciones generales, sin alteraciones en el examen abdominal. Su especuloscopía muestra escaso sangrado uterino. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A Solicitar ecografía y niveles plasmáticos de gonadotropina coriónica humana

B Control con ecografía en 7 días

C Realizar una laparoscopía exploradora inmediata

D Realizar legrado uterino.

E Solicitar una resonancia magnética nuclear de pelvis

Respuesta A. Metrorragia en el Embarazo: En una paciente con metrorragia en la primera mitad del embarazo (por las 6 semanas de amenorrea con prueba de embarazo positiva), se debe solicitar una ecografía para diferenciar entre aborto, embarazo ectópico y mola. Los niveles de gonadotropina coriónica humana ayudan a identificar embarazos ectópicos, con valores superiores a 3.500 UI/L y ecografía negativa para gestación intrauterina. La paciente presenta estabilidad hemodinámica, lo que reduce la sospecha de...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 3

Una paciente consulta por atraso menstrual de 7 semanas y trae test de embarazo en orina, que resulta positivo. Se realiza una ecografía transvaginal, que no visualiza embarazo intrauterino y que constata la presencia de un tumor anexial derecho, complejo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Solicitar niveles de HCG en sangre

B Solicitar una nueva ecografía transvaginal en 7 días

C Solicitar marcadores tumorales en sangre

D Solicitar proteína plasmática asociada al embarazo

E Solicitar niveles de progesterona y estradiol

Respuesta A. Ante la sospecha de embarazo ectópico, se debe pedir HCG. Si es menor a 1.500 U/L, puede ser un embarazo normal, pero de menor edad gestacional y se debe esperar 48 horas y repetir la HCG. Si la HCG es mayor a 1.500 U/L, se confirma el diagnóstico (aunque en las recomendaciones norteamericanas más recientes, se sugiere esperar a que sea mayor a 3.500, o bien a que no suba al menos un 66% en 48 horas, antes de dar el metotrexato) y se procede al tratamiento con metotrexato o cirugía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 155

Una paciente de 27 años consulta por dolor abdominal bajo de 5 horas de evolución. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, presión arterial 110/70 mmHg, examen cardiopulmonar normal y abdomen blando, sin signos peritoneales, con dolor a la palpación del hipogastrio. Se solicita subunidad beta de gonadotropina coriónica que resulta en 1.000 UI/L y se realiza ecografía transvaginal que muestra endometrio de 17 mm, sin lesiones anexiales ni visualización de líquido libre en la pelvis. Además de hospitalizar, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A Iniciar metotrexato

B Realizar laparoscopía exploradora

C Repe2r la gonadotropina coriónica en 48 horas

D Realizar legrado uterino

E Solicitar TAC de abdomen y pelvis

Respuesta C. La sospecha es un embarazo ectópico (prueba de embarazo positiva + ecografía negativa) no complicado (hemodinamia estable y ausencia de líquido libre). Por tener HCG menor a 3.500 UI/L también puede tratarse de un embarazo normal intrauterino, pero pequeño. Se debe controlar con HCG en 48 horas. Si aumenta al menos un 66% probablemente sea un embarazo normal; si eleva menos que eso, se confirma el embarazo ectópico y se puede tratar con metotrexato u observación, si la HCG se mantiene menor a...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 81

Una paciente de 26 años, con atraso menstrual de 3 semanas, consulta por metrorragia escasa, sin dolor. Al examen físico. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra tumor anexial de 3 cm, sin líquido libr

E Los niveles de HCG resultan 3.400 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Controlar con ecografía en 48 horas

B Adminstrar metotrexato

C Controlar con HCG en 48 horas

D Realizar legrado

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Controlar con HCG en 48 horas). Las opciones alternativas (Los niveles de HCG resultan 3.400 UI/L.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 124

Una paciente de 23 años, nulípara, consulta por presentar metrorragia desde ayer, no asociado a otros síntomas. Se realizó prueba de embarazo en orina que resultó positiva. Al examen físico se aprecia sangre proveniente del orificio cervical externo. Se realiza ecografía transvaginal que muestra útero sin alteraciones y una masa anexial derecha solidoquística de tres centímetros de diámetro. Además se solicitan niveles de gonadotrofina coriónica que se encuentran en 700 mUI/mL. La conducta más adecuada en este caso es:

A Indicar tratamiento con metotrexato

B Controlar con niveles de gonadotrofina coriónica y ecografía transvaginal en 48 horas

C Controlar con nueva ecografía transvaginal en siete días

D Hospitalizar y realizar salpingectomía derecha

E Indicar reposo y controlar con niveles de gonadotrofina coriónica y ecografía transvaginal en siete días

Respuesta B. Como la metrorragia no es grave (si fuera grave habría que operar de inmediato por EE roto), se puede pedir la BetaHCG en 2 días, junto a la Eco, ya que está menor a 1.200. El diagnóstico probable es un embarazo de menor edad gestacional, con síntomas de aborto, vs un embarazo ectópico, con metrorragia, sin estar del todo roto. Recordar que los EE producen también metrorragia por la insuficiencia lútea que tienen, dados los bajos niveles de HCG que alcanzan.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 77

Mujer de 24 años con amenorrea de 5 semanas y dolor hipogástrico leve. B-hCG cuantitativa: 800 mUI/mL. Ecografía transvaginal: no se visualiza saco gestacional intrauterino. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Alta con control en 1 semana

B Repetir B-hCG en 48 horas (debe duplicar si el embarazo es viable)

C Ecografía abdominal

D Laparoscopia diagnóstica inmediata

E Metotrexato intramuscular inmediato

Respuesta B. B-hCG 800 sin saco visible: la "zona discriminatoria" es ~1500-2000 mUI/mL para visibilizar saco por ecografía TV. Con 800, puede ser embarazo intrauterino muy precoz. Conducta: repetir B-hCG en 48h → si duplica, probablemente viable intrauterino; si sube <50% o baja, probable ectópico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 81

Una paciente de 32 años, usuaria de DIU, con antecedente FUR dudosa hace más de un mes, consulta por dolor abdominal bajo, asociado a escaso sangrado genital. Al examinarla, se constata PA: 110/70 mmHg, FC: 100x', abdomen blando, depresible, con dolor a la palpación de la zona abdominal baja. En el examen ginecológico se observan las guías del DIU y se aprecia escasa metrorragia, que proviene del orificio cervical externo. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A Ecografía transvaginal

B Gonadotropina coriónica plasmática

C Radiografía de abdomen y pelvis

D Laparoscopía exploradora

E Hemograma y PCR

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Gonadotropina coriónica plasmática). Se sospecha un embarazo ectópico y es lo primero a descartarse.

▶ VER CLASE 3.01.1.007 **Embarazo múltiple** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.21 · Cardiopatía, Embarazo Múltiple e Hiperemesis Gravídica: Riesgo Materno, Corionicidad y Manejo Inicial

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: altura uterina mayor a la esperada, hiperémesis, hCG muy elevada, antecedente de fertilización asistida; la ecografía del 1.er trimestre confirma.
- Lo clave es definir la corionicidad entre las 11 y 14 semanas: signo lambda (bicorial) vs signo T (monocorial); el monocorial tiene más riesgo (transfusión feto-fetal).
- Riesgos maternos y fetales aumentados: parto prematuro, preeclampsia, diabetes gestacional, anemia, RCF, presentaciones anómalas e hemorragia posparto.
- Manejo inicial: suplementar hierro y ácido fólico, aspirina 150 mg si hay otro factor de riesgo de preeclampsia, y derivar a control en alto riesgo obstétrico.
- Vigilancia ecográfica seriada (cada 2 semanas desde las 16 si es monocorial); interrupción habitual: bicorial 37–38 semanas, monocorial biamniótico 36–37, monoamniótico 32–34 por cesárea.
- Seguimiento: derivar a especialista; vía de parto según presentación del primer gemelo (cefálico permite parto vaginal en bicorial).

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 54

Una paciente de 34 años, cursando su primer embarazo, gemelar, bicorial biamniótico, de 26 semanas de edad gestacional. Se controla con ecografía obstétrica, que visualiza un gemelo muerto, sin compromiso hemodinámico del gemelo sobreviviente. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar extracción del feto muerto
B Realizar controles periódicos con dímero D
C Interrumpir el embarazo
D Realizar cesárea a las 37 semanas
E Realizar controles periódicos con pruebas de coagulación

Respuesta E. En un embarazo bicorial de 26 semanas se puede mantener la conducta expectante, pero el feto muerto retenido es un gatillo obstétrico de CID. Se vigila con pruebas de coagulación, porque el dímero D se eleva normalmente durante el embarazo y no sirve para seguir a esta paciente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 59

Paciente de 39 años, cursando un embarazo gemelar bicorial biamniótico de 36 semanas, acude a control. Está en buenas condiciones generales, sin síntomas, con signos vitales normales. La ecografía muestra al primer gemelo con peso fetal estimado de 2.850 g y al segundo con 2.750 g, con líquido amniótico normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar control ecográfico en una semana
B Programar cesárea electiva a las 38 semanas
C Inducir el parto de inmediato
D Solicitar ecografía Doppler de arterias uterinas
E Realizar cesárea de urgencia

Respuesta A. Gemelar bicorial no complicado, con crecimiento concordante y bienestar conservado: se mantiene vigilancia seriada y se interrumpe alrededor de las 37 a 38 semanas. A las 36 semanas no hay indicación de interrupción inmediata, y la vía de parto depende de la presentación del primer gemelo, no del embarazo gemelar en sí.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 143

ecografía-doppler, que muestra discordancia de crecimiento de 28%, perfil biofísico tranquilizador y doppler con aumento de la resistencia umbilical y flujo presente en diástole. Ambos fetos se encuentran en posición cefálica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar cesárea ahora
B Inducir el parto ahora
C Realizar control seriado con doppler fetal
D Administrar corticoides antenatales
E Repetir el perfil biofísico

Respuesta C. Tiene gemelos discordantes (uno es 25% más chico que el otro), que, aunque la mayoría además cumple con que uno de ellos es RCIU, en este caso no se menciona. De todos modos, el manejo es similar al RCIU. En este caso, tiene un doppler con alteraciones, pero, de baja gravedad (aumento de la resistencia), ya que aún hay flujo en diástole. Por tanto, no es necesario interrumpir aún y se debe seguir con el Doppler. Eso sí,

▶ VER CLASE 3.01.1.008 Enfermedad del trofoblasto

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Obstetricia 19.12 · Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Mola hidatiforme: metrorragia indolora del 1.er trimestre, útero mayor que la edad gestacional, hiperémesis y beta-hCG muy elevada (>100.000).
- Preeclampsia antes de las 20 semanas o hipertiroidismo con embarazo inicial: pensar en mola. Ecografía: patrón en tormenta de nieve (vesículas) sin embrión en la completa.
- Completa: 46,XX paterno, sin embrión, riesgo de neoplasia 15–20%; parcial: triploide 69, embrión malformado, riesgo 1–5%.
- Tratamiento inicial: evacuación por aspiración (AMEU) con oxitocina, biopsia de todo el material; Rh(–): anti-D. Derivar a ginecología.
- Seguimiento: beta-hCG semanal hasta 3 valores normales seguidos y luego mensual por 6 meses, con anticoncepción obligatoria.
- hCG que se estanca o sube = neoplasia trofoblástica gestacional: etapificar y quimioterapia (metotrexato); derivar a oncología ginecológica.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 82

Paciente de 25 años acude por metrorragia abundante de 2 días, con atraso menstrual de 4 semanas, dudoso por reglas irregulares. La palpación uterina muestra un útero aumentado de tamaño como para un embarazo de 12 semanas. La beta-hCG resulta 200.000 unidades por litro, y la ecografía transvaginal muestra imagen en tormenta de nieve. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Aborto en evolución
B Embarazo ectópico roto
C Mola hidatiforme
D Metrorragia disfuncional
E Tumor del sitio de inserción placentaria

Respuesta C. La imagen en tormenta de nieve junto con la beta-hCG muy elevada y el útero mayor a la edad gestacional confirman la mola hidatiforme.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 174

Mujer de 30 años, cursando un embarazo inicial, presenta un aborto espontáneo, manejado con legrado, sin complicaciones. Se controla dos semanas después y la biopsia es informada como mola hidatiforme. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar anticonceptivos orales por 12 meses

B Controlar con beta-hCG seriada

C Controlar con ecografía transvaginal en 2 semanas

D Quimioterapia profiláctica

E Realizar histerectomía

Respuesta B. El hallazgo de mola en la biopsia obliga al seguimiento hormonal seriado para detectar precozmente una neoplasia trofoblástica, junto con anticoncepción durante todo el seguimiento.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 138

Mujer de 25 años presenta un aborto espontáneo hace 2 meses, que no requirió legrado. Actualmente presenta metrorragia de 7 días, que en la especuloscopía sale por el orificio cervical externo. Su beta-hCG resulta 135.000 unidades por litro. La ecografía transvaginal muestra útero aumentado de tamaño, con contenido uterino irregular y múltiples vesículas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar metotrexato

B Esperar evolución espontánea

C Realizar legrado

D Realizar resonancia magnética de pelvis

E Realizar histerectomía

Respuesta E. Una mola que persiste sin tratamiento durante dos meses, con beta-hCG muy elevada y hallazgos molares francos, corresponde ya a una neoplasia trofoblástica establecida, que se trata con histerectomía y quimioterapia posterior.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 22 años, con doce semanas por fecha de última regla, consulta por metrorragia y vómitos intensos. El útero se palpa como de dieciocho semanas. La beta-hCG resulta 190.000 unidades por litro, y la ecografía transvaginal muestra la cavidad ocupada por múltiples quistes pequeños, sin saco gestacional ni embrión. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inicial más adecuada?**

A Mola hidatiforme completa; evacuación con aspiración manual endouterina

B Aborto retenido; misoprostol vaginal

C Embarazo gemelar; control ecográfico en 4 semanas

D Mola parcial; quimioterapia profiláctica de inmediato

E Embarazo ectópico; metotrexato intramuscular

Respuesta A. Útero mucho mayor a la edad gestacional, beta-hCG extremadamente elevada y el patrón ecográfico en tormenta de nieve, sin embrión, son diagnósticos de mola completa. El tratamiento inicial es la evacuación con aspiración manual endouterina, con estudio histopatológico de todo el material.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 155

Una paciente se realiza un legrado por un aborto espontáneo. La biopsia es informada como “mola completa”. Su HCG postlegrado es de 750 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Seguirla con niveles seriados de HCG

B Realizar biopsia endometrial

C Indicar anticonceptivos con progestágeno solo

D Repetir el legrado

E Indicar metotrexato

Respuesta A. Ante un embarazo molar se debe seguir con HCG, después de sacarla. Si se eleva o mantiene sin bajar, se diagnostica neoplasia trofoblástica gestacional y se procede a la histerectomía más quimioterapia con metotrexato. Una HCG de 750 postlegrado, es bastante baja.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 65

Paciente de 34 años, sin antecedentes, consulta por atraso menstrual asociado a metrorragia abundante, náuseas y vómitos. Al examen físico se aprecian mucosas pálidas, útero a nivel suprapúbico y se palpan masas anexiales bilaterales no sensibles. El diagnóstico más probable es:

A Embarazo normal

B Aborto en evolución

C Adenomiosis

D Embarazo gemelar

E Embarazo molar

Respuesta E. Diagnóstico: Embarazo molar (opción E). Es una mola completa, con los quistes tecoluteínicos, la metrorragia y los vómitos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 90

Mujer de 40 y tantos con aborto y a la especuloscopía se ve salida de vesículas: a. Enfermedad trofoblastica

A Ninguna de las anteriores es correcta
B Todas las anteriores son correctas
C No se dispone de información suficiente
D Otra alternativa no descrita
E Otra alternativa no descrita

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Ninguna de las anteriores es correcta).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 145

Una paciente de puérpera de 3 meses, cuyo parto fue por vía vaginal, sin complicaciones. Sin embargo, desde entonces presenta metrorragia intermitente, que ha aumentado. Está dando lactancia materna y no ha tenido otros síntomas. Se solicita ecografía transvaginal, que muestra endometrio de 17 mm de grosor, con algunas imágenes quísticas en su interior. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A Niveles de HCG
B Resonancia magnética nuclear de pelvis
C Biopsia de endometrio
D TAC de pelvis
E Histeroscopía

Respuesta C. Es una pregunta muy discutible y que no tiene una respuesta clara. Tiene una insuficiencia renal, con hiperkalemia, hiponatremia y acidosis metabólica. De las complicaciones, la hiperkalemia es la más urgente de mejorar, por el riesgo de evolucionar a una pregunta muy discutible y, además, de manejo de especialista. Lo que se pregunta es una NTG, en específico un tumor del sitio de inserción placentaria (las más rara de todas y la que menos eleva la HCG, en comparación con las molas). La...

▶ VER CLASE 3.01.1.009 Macrosomía fetal

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.7 · Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia

QUÉ HAY QUE SABER

- Macrosomía: peso fetal estimado o al nacer ≥4.000 g (o >p90 para la edad gestacional, GEG).
- Sospecha: altura uterina mayor a la esperada, diabetes (pregestacional o gestacional mal controlada), obesidad materna, ganancia de peso excesiva, macrosómico previo, postérmino.
- Mecanismo en diabetes: la glucosa cruza la placenta y la insulina no; el hiperinsulinismo fetal deposita grasa en hombros y tronco.
- Riesgos: distocia de hombros, lesión del plexo braquial, desgarros, hemorragia posparto e hipoglicemia neonatal.
- Manejo inicial: confirmar con ecografía (estimación imprecisa ±15%), optimizar control glicémico; considerar cesárea si EPF ≥4.500 g en diabética, ≥5.000 g en no diabética o si hubo distocia de hombros previa.
- Seguimiento: no requiere controles especiales posteriores; vigilar glicemia del recién nacido y reclasificar a la madre si es diabética.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 40

Una paciente de 32 años ingresa en trabajo de parto con 38 semanas de gestación. Al examen obstétrico presenta buena dinámica uterina, feto en presentación cefálica apoyada y dilatación cervical de 3 cm. El peso fetal estimado es de 4.200 g. Tiene antecedente de un parto vaginal previo a las 39 semanas, con retención de hombros y un peso al nacer de 3.900 g. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Conducir el trabajo de parto
B Iniciar goteo oxitócico
C Administrar tocolíticos
D Realizar cesárea en este momento
E Determinar la vía de parto una vez completada la dilatación

Respuesta D. Feto macrosómico estimado en 4.200 g, 300 g más que el hijo previo que tuvo retención de hombros: el riesgo de una nueva distocia de hombros es alto y lo razonable es la cesárea ahora. Conducir o esperar la dilatación completa expone a esa distocia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 97

Embarazo 38 sem 4300g cesárea previa a las X sem por desproporción cefalo pélvica (guagua pesaba 3900). Conducta:

A cesarea inmediata
B programar cesarea 39 semanas
C esperar inicio tdp
D Interrupción del embarazo
E Maduración pulmonar y observación

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: cesarea inmediata (opción A). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

▶ VER CLASE **3.01.1.010** **Restricción de crecimiento fetal** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.4 · Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: altura uterina menor a la esperada (≥3–4 cm bajo lo esperado) o ecografía con peso fetal estimado <p10; confirmar la EG con ecografía precoz.
- Peso p3–p10 con Doppler normal = PEG constitucional (sano, parto a término 39–40 semanas); <p3 o Doppler alterado en cualquier percentil, o caída >2 canales = restricción de crecimiento.
- Causas: insuficiencia placentaria (preeclampsia, HTA, tabaco, trombofilias), genéticas, infecciones (TORCH), embarazo múltiple.
- Precoz (<32 semanas) se asocia a preeclampsia y deterioro Doppler ordenado (umbilical → cerebral → ductus); tardío (≥32) con umbilical normal y cerebral media alterada.
- El examen clave es el Doppler de arteria umbilical; etapas: I → 37 semanas; II (diástole ausente) → 34; III (diástole reversa) → 30; IV (ductus con onda a reversa) → interrupción inmediata.
- Manejo inicial: derivar a alto riesgo; corticoides si <34 semanas (betametasona 12 mg IM c/24 h x2) y sulfato de magnesio neuroprotector si <32. Seguimiento: derivar.

PREGUNTAS · 9

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 24

Paciente de 34 años, con embarazo de 35 semanas, con feto creciendo en percentil 2 desde la semana 33, con Doppler fetal normal en ese entonces. Se solicita un nuevo Doppler de control, que no muestra alteraciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Inducir el parto
B Realizar cesárea
C Solicitar perfil biofísico
D Controlar semanalmente con Doppler
E Interrumpir a las 37 semanas

Respuesta B. Un percentil 2 define restricción de crecimiento severa, independiente de que el Doppler siga normal: la severidad por percentil ya obliga a interrumpir a las 34 semanas, y por cesárea.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 168

Paciente cursando un embarazo de 35 semanas, es diagnosticada de restricción de crecimiento fetal en percentil 3. **¿Cuál de las siguientes alteraciones es indicación de interrupción inmediata del embarazo?**

A Oligohidramnios
B Aumento de la resistencia de las arterias umbilicales
C Dilatación de la arteria cerebral media
D Relación fémur/abdomen mayor a 0,25
E Ductus venoso con flujo ausente en diástole

Respuesta E. El Doppler del ductus venoso alterado (flujo ausente o, más grave aún, onda a reversa) es el hallazgo más ominoso de la cascada, y su aparición obliga a la interrupción inmediata del embarazo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 56

Paciente multípara de 40 años, con un embarazo de 32 semanas. La ecografía muestra líquido amniótico normal, con un feto creciendo en percentil 10, con un peso fetal estimado de 1.320 gramos. **¿Cuál es la actitud más adecuada?**

A Observar evolución
B Solicitar Doppler de arterias uterinas
C Solicitar Doppler de arteria umbilical
D Repetir la ecografía obstétrica en 2 semanas
E Inducir maduración pulmonar con corticoides

Respuesta C. Ante un feto bajo el percentil 10, el examen de elección para diferenciar un PEG constitucional de una restricción de crecimiento, y para etapificar su gravedad, es el Doppler de arteria umbilical.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 161

Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 37 semanas, tiene una altura uterina de 28 cm. Se realiza una ecografía obstétrica, que muestra un feto creciendo en percentil 8, con ILA de 8 cm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Inducir el parto con misoprostol
B Realizar registro basal no estresante
C Observar evolución
D Realizar doppler materno fetal
E Realizar operación cesárea

Respuesta D. Pregunta muy específica. Tiene un RCIU leve (percentil mayor a 5), con líquido amniótico límite, aunque al término, se considera normal hasta ILA de 5. Hoy en día, se pide Doppler umbilical, porque si está normal, se puede incluso llegar a término. Antes se interrumpían todos los RCIU a más tardar a las 37 semanas (hoy solo los moderados-severos o los con doppler alterado).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 149

Una paciente de 30 años, cursando embarazo de 36 semanas, con feto creciendo en percentil 6 en la semana 35, con Doppler materno fetal normal en ese entonces. Se realiza ecografía de control que muestra feto que no ha crecido, en presentación podálica y Doppler normal. El registro basal no estresante es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Solicitar perfil biofísico

B Administrar corticoides

C Interrumpir a las 37 semanas

D Realizar cesárea en este momento

E Continuar el control semanal con Doppler

Respuesta E. Pregunta difícil. Tiene un RCIU leve (p5 a p9) con Doppler normal, por lo que sería un RCIU tipo I, que se interrumpe a las 37 semanas o incluso a las 40 semanas, si es que se considera un PEG (todo bien y Doppler normal, como en este caso). Para hablar de detención del crecimiento deben pasar al menos 2 semanas, ya que en un tiempo menor está dentro de la variabilidad de la misma ecografía. Por tanto, en este caso, se debe seguir controlando con el Doppler semanal. Si tuviera menos de 34...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 123

Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 37 semanas, tiene una estimación de peso fetal en el percentil 5 para la edad gestacional. Se realiza una ecografía obstétrica, que confirma feto con peso en percentil 5 para la edad e índice de líquido amniótico de 6. La conducta más adecuada es:

A Solicitar registro basal no estresante

B Inducir el parto

C Solicitar Doppler maternofetal

D Realizar amnioinfusión

E Realizar cesárea

Respuesta C. Tiene un RCIU leve (p5 a p9), con un ILA normal para la edad gestacional (OHA se define como ILA menor a 8 o menor a 5 si es de término; por tanto, no hay OHA en este caso). Sea como sea, todo RCIU siempre debe estudiarse con un doppler maternofetal, ya que si todo está bien, puede ser PEG y se puede esperar a las 40 semanas y nacer por vía vaginal; si está alterado el doppler, se debe interrumpir por cesárea (por tener ya 37 semanas). Revisar manejo y edades de interrupción del RCIU

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 156

Una paciente de 34 años, cursando un embarazo de 38 semanas, con antecedente de RCIU en percentil 5. Se realiza una ecografía obstétrica, que muestra feto creciendo en percentil menor a 5 y oligohidroamnios. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Administrar corticoides, manteniendo una conducta expectante

B Realizar cesárea dentro de las próximas 24 horas

C Inducir el parto con misoprostol

D Solicitar doppler umbilical y decidir según resultados

E Realizar test de tolerancia a las contracciones

Respuesta B. Es un RCIU, con criterios de interrupción (mayor a 37 semanas y además OHA y además detención del crecimiento). Se prefiere la cesárea para evitar el estrés del trabajo de parto.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 29

Embarazada de 35 semanas, con altura uterina menor a lo esperado, es derivada a alto riesgo obstétrico donde se realiza ecografía que muestra feto de 1.800 gramos y el doppler umbilical muestra flujo reverso en diástole. La paciente está en buenas condiciones, sin dinámica uterina y su tacto vaginal no presenta cambios cervicales. La conducta más adecuada es:

A Inducir con misoprostol y conducir trabajo de parto

B Interrumpir por cesárea

C Hospitalizar para estudio de la unidad fetoplacentaria

D Solicitar estudio de líquido amniótico

E Indicar reposo y control en 48 horas

Respuesta B. Tiene un RCIU mayor a 34 semanas y cuyo Doppler umbilical está alterado, por lo que se debe interrumpir. Por tener el doppler alterado, es decir, insuficiencia placentaria no se lo debe someter al estrés del parto vaginal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 164

Una paciente de 25 años, cursando embarazo de 35 semanas, acude a control ginecológico asintomática. Su examen físico es normal. Se realiza ecografía donde se estima peso fetal en percentil 8 para su edad gestacional. La conducta más adecuada en este caso es:

A Realizar perfil biofísico

B Medición del flujo cerebral y umbilical

C Medición del flujo de arterias uterinas

D Realizar ecografías seriadas

E Interrupción del embarazo

Respuesta B. Tiene un RCIU leve, de 35 semanas. Hay que pedir Doppler umbilical y se puede ver además con el de ACM. Pero también se debe pedir un PBF y la eco en 14 días. A grandes rasgos, el Doppler es el examen más importante en el RCIU. Esta pregunta está técnicamente mala, pero para asunto de examen RCIU = doppler umbilical (que se puede complementar con doppler de ACM y de ducto venoso).

▶ VER CLASE 3.01.1.011

Síndrome hipertensivo del embarazo

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA

Obstetricia 19.5 · Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad
Obstetricia 19.6 · Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio

QUÉ HAY QUE SABER

- HTA en embarazo: PA ≥140/90 en 2 tomas separadas por 4 h. Antes de 20 semanas o persistente posparto = crónica; después de 20 sin proteinuria = gestacional; con proteinuria o daño de órgano = preeclampsia.
- Proteinuria significativa: ≥300 mg/24 h o índice proteinuria/creatininuria ≥0,3. Sin proteinuria, plaquetopenia, alza de transaminasas o creatinina también definen preeclampsia.
- Severidad (basta uno): PA ≥160/110, plaquetas <100.000, transaminasas al doble, creatinina alta, cefalea, escotomas, epigastralgia, edema pulmonar.
- Tratamiento oral: labetalol, metildopa o nifedipino de liberación prolongada; IECA y ARA-II contraindicados (suspender si los usaba).
- Preeclampsia sin severidad: interrupción a las 37 semanas; hipertensión gestacional: 38–39 semanas. Con severidad: sulfato de magnesio e interrupción según estabilidad.
- Prevención: aspirina 150 mg nocturna desde antes de las 16 semanas en alto riesgo (preeclampsia previa, Doppler uterino alterado). Seguimiento: derivar a alto riesgo obstétrico.

PREGUNTAS · 12

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 173

Paciente de 25 años cursando su primer embarazo de 37 semanas acude a control. Se observa leve edema de extremidades inferiores, presión arterial de 140/90 mmHg y frecuencia cardíaca fetal de 125 latidos por minuto. Está asintomática. **¿Qué examen es más adecuado para precisar el diagnóstico?**

A Monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas

B Ecografía Doppler renal

C Ecografía obstétrica con Doppler fetal

D Proteinuria de 24 horas

E Test de tolerancia a las contracciones

Respuesta D. Con presión igual o mayor a 140/90 mmHg después de la semana 20, lo que decide entre hipertensión gestacional y preeclampsia es la proteinuria. El edema aislado orienta pero no define; la proteinuria de 24 horas sí.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 10

Paciente de 41 años, embarazada de 24 semanas, con presión arterial de 155/100 mmHg. Los exámenes muestran una proteinuria en 24 horas de 280 mg y el examen físico es normal, sin edema ni signos de preeclampsia severa. **¿Cuál es el tratamiento más apropiado?**

A Iniciar metildopa oral

B Iniciar hidralazina intravenosa

C Observación y control en 1 semana

D Iniciar nifedipino de acción prolongada

E Sulfato de magnesio intravenoso

Respuesta A. La proteinuria de 280 mg queda bajo el corte de 300 mg, así que todavía no es preeclampsia. Pero la presión ya justifica tratamiento oral, y el fármaco de elección en este contexto es la metildopa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 155

Paciente de 33 años, con 13 semanas de embarazo, con antecedente de cesárea de urgencia en un embarazo anterior, a las 31 semanas, por una preeclampsia severa. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar aspirina
B Indicar heparina
C Indicar L-arginina
D Indicar ácidos grasos omega 3
E Indicar dexametasona

Respuesta A. El antecedente de preeclampsia severa previa define alto riesgo para este embarazo. La medida que reduce esa recurrencia es la aspirina en dosis baja, idealmente iniciada antes de las 16 semanas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 126

Embarazada de 32 semanas con dolor epigástrico y en hipocondrio derecho de 2 días. Plaquetas 80.000/mm³, bilirrubina 2,0 mg/dL, GOT 320 UI/L, GPT 240 UI/L. La ecografía muestra litiasis vesicular. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Pancreatitis aguda
B Hepatitis viral
C Colecistitis aguda
D Colestasia intrahepática
E Síndrome de HELLP

Respuesta E. Plaquetas bajas, transaminasas elevadas y bilirrubina indirecta alta cumplen los tres criterios de HELLP. La litiasis vesicular es un distractor: en el embarazo es un hallazgo frecuente e incidental.

PREGUNTA REAL · EUNACOM 2023 · PREGUNTA 18

¿Cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos se encuentra formalmente CONTRAINDICADO en un paciente con diagnóstico de fenómeno de Raynaud debido al riesgo de desencadenar o agravar crisis de vasoespasmo digital severo?

A Losartán oral
B Enalapril oral
C Amlodipino oral
D Propranolol oral (Betabloqueador no selectivo)
E Hidroclorotiazida oral

Respuesta D. Los betabloqueadores (especialmente los no cardioselectivos como el propranolol) están formalmente contraindicados en pacientes con fenómeno de Raynaud. Al bloquear los receptores beta-2 adrenérgicos vasculares, predomina el tono alfa-adrenérgico vasoconstrictor, lo que puede precipitar o agravar severamente las crisis de isquemia digital e incluso gatillar necrosis.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Secundigesta de 34 semanas, con hipertensión arterial crónica en tratamiento con enalapril desde hace 3 años, acude por primera vez a control en este embarazo. Se constata PA de 144/92 mmHg, confirmada a los 15 minutos. Está asintomática, con altura uterina acorde y latidos cardiofetales presentes. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A Mantener el enalapril y solicitar proteinuria de 24 horas
B Suspender el enalapril e iniciar labetalol o metildopa
C Aumentar la dosis de enalapril para lograr mejor control
D Indicar sulfato de magnesio de forma profiláctica
E Interrumpir el embarazo de inmediato

Respuesta B. El enalapril está absolutamente contraindicado en el embarazo por su teratogenicidad renal fetal. La conducta inmediata es suspenderlo y reemplazarlo por un antihipertensivo seguro, además de estudiar proteinuria y Doppler para descartar preeclampsia sobreagregada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 141

Una paciente de 32 años con antecedente de síndrome hipertensivo del embarazo, a las 32 semanas no logra cifras tensionales normales a pesar de las medidas no farmacológicas. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más adecuado para continuar con el tratamiento?

A Losartán
B Enalapril
C Nifedipino
D Espironolactona
E Doxazosina

Respuesta C. Antihipertensivos en el Embarazo: En el embarazo, la mayoría de los antihipertensivos están contraindicados. Los cuatro medicamentos que se pueden usar son alfametildopa, nifedipino (de liberación prolongada o XR), hidralazina y labetalol vía oral (más eficaz, pero su disponibilidad es limitada).

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 50

Embarazada sobre 20 semanas con dolor epigástrico, hipertensión, transaminasas elevadas y trombocitopenia. ¿Diagnóstico más probable?

A Preeclampsia severa sin criterios de HELLP
B Síndrome de HELLP
C Colestasia intrahepática del embarazo
D Hepatitis aguda viral
E Hígado graso agudo del embarazo

Respuesta B. Diagnóstico: Síndrome de HELLP (opción B). Síndrome de HELLP. El score de Tal es la herramienta clínica utilizada para evaluar la severidad del síndrome bronquial obstructivo (SBO).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 28

paciente embarazada con hemograma patológico, enzimas hepáticas elevadas, litisis vesicular, hta, hipoglicemia, dolor y fiebre

A sd hellp o higado graso agudo (en discusión)
B Hepatitis viral
C Preeclampsia severa
D Colestasia intrahepática
E Hígado graso agudo del embarazo

Respuesta A. Embarazada con HELLP + hígado graso agudo del embarazo (HGAE): ambas son emergencias obstétricas con laboratorio similar. En contexto de embarazo con hepatopatía grave, interrupción urgente es la conducta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 100

Una paciente primigesta, cursando un embarazo de 38 semanas, presenta presiones arteriales cercanas a 150/90 mmHg. Está en buenas condiciones generales, sin exaltación neurológica, ni otros síntomas. Se solicita proteinuria de 24 horas, que resulta 400 mg. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Solicitar ecodoppler de arterias umbilicales
B Realizar operación cesárea
C Solicitar monitoreo fetal no estresante
D Inducir el parto
E Repetir la proteinuria en 2 semanas

Respuesta D. Tiene una preclamsia, que pareciera ser moderada, aunque falta información para estar seguro. De todos modos, por haber llegado al término, se debe interrumpir el embarazo. No hay indicación de cesárea con la información que se entrega. Sin embargo, es una pregunta que induce a error, porque no está de más, evaluar el bienestar fetal antes, ya que en toda paciente con preclamsia debería hacerse un Doppler fetal. Sin embargo, a mi parecer lo correcto es la interrupción, ya que ese es el...

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 48

Una paciente de 25 años, primigesta, cursa un embarazo de 29 semanas. Consulta por dolor abdominal de 2 días de evolución, de localización epigástrica, asociada a vómitos y malestar general. En su examen físico presenta FC: 90x', PA: 147/100 mmHg, FR: 12x', abdomen depresible, doloroso en la palpación epigástrica y más intenso en hipocondrio derecho. Sus exámenes muestran creatinina plasmática: 1,2 mg/dl, electrolitos plasmáticos normales, hemoglobina: 10,6 g/dl, plaquetas: 90.000 por mm3, blancos: 12.000 por mm3, LDH: 720 UI/L, PCR: 5,0, bilirrubina: 1,4 mg/dl, SGPT: 248 UI/L y SGOT: 277 UI/L. Su ecografía abdominal muestra cálculos biliares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Síndrome de HELLP
B Colecistitis aguda
C Hígado graso agudo del embarazo
D Colestasia intrahepática del embarazo
E Colangitis

Respuesta A. Tanto por la presión elevada, como por la anemia, plaquetopenia y elevación de la LDH es un HELLP clásico. Los cálculos biliares solo están como distractor.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 154

Una paciente de 22 semanas de gestación, con embarazo bien controlado, se realiza un doppler de arterias uterinas, que demuestra aumento de la resistencia. Como antecedente, estuvo hospitalizada en un embarazo anterior por una preclamsia. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Iniciar aspirina
B Iniciar heparina
C Iniciar L-arginina
D Mantener el control normal del embarazo
E Administrar corticoides

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Iniciar aspirina (opción A). Por ser una paciente de alto riesgo, debe recibir profilaxis de PE con aspirina.

▶ VER CLASE **3.01.1.012** **Amenorrea** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.1 · Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

QUÉ HAY QUE SABER

- Amenorrea primaria: sin menarquia a los 15 años (o 13 sin caracteres sexuales secundarios); secundaria: ausencia de regla por 3 meses (6 si era irregular).
- Secundaria, paso a paso: beta-hCG siempre primero (embarazo es lo más frecuente); luego TSH y prolactina; después test de progesterona (sangra = anovulación, ej. SOP).
- Si no sangra: test de estrógeno + progesterona; si no sangra = causa uterina (Asherman tras legrado → histeroscopía); si sangra, FSH: alta = falla ovárica, baja = hipotalámico-hipofisaria.
- Primaria: sin útero → cariotipo (46,XX Rokitansky; 46,XY Morris, mamas sin vello); con útero → FSH (alta: Turner; baja: Kallmann con anosmia). Himen imperforado: dolor cíclico sin sangrado.
- Manejo inicial: hiperprolactinemia → cabergolina; amenorrea hipotalámica (estrés, anorexia, deportistas) → recuperar peso; insuficiencia ovárica prematura (<40 años) → terapia hormonal hasta los 50.
- Banderas rojas: hemianopsia bitemporal (macroprolactinoma, RM urgente), gónada con cromosoma Y (gonadectomía). Seguimiento: derivar a ginecología/endocrinología.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 84

Una paciente de 38 años, multípara de 4, con antecedente de 5 abortos que requirieron legrado, nota disminución progresiva del flujo menstrual, hasta caer en amenorrea desde hace 100 días. Su examen físico no muestra alteraciones y no utiliza métodos anticonceptivos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Síndrome de Asherman
B Menopausia precoz
C Hiperprolactinemia
D Síndrome de ovario poliquístico
E Hipopituitarismo

Respuesta A. El antecedente de legrados repetidos con disminución progresiva del flujo hasta la amenorrea es el cuadro clásico del síndrome de Asherman: las sinequias uterinas obliteran la cavidad y el endometrio deja de responder.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 18

Una paciente de 17 años consulta por amenorrea de 4 meses de evolución. Su examen físico no muestra alteraciones. Test de embarazo negativo, TSH y prolactina dentro de rangos normales. Se solicita prueba de progesterona, que resulta negativa, y prueba de estrógeno y progesterona, que resulta positiva. Además, LH y FSH están normales, en el límite bajo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Macroadenoma hipofisiario
B Falla ovárica primaria
C Embarazo ectópico
D Amenorrea hipotalámica
E Síndrome de ovario poliquístico

Respuesta D. El test de progesterona negativo descarta anovulación con estrógenos presentes; el test combinado positivo confirma que el endometrio y el tracto de salida responden; y con LH y FSH en el límite bajo, el hipogonadismo es hipogonadotrópico, es decir, de causa hipotalámica o hipofisiaria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 25

Una paciente de 33 años consulta porque desde hace 95 días que no ha menstruado. Sus reglas previas eran regulares, es sexualmente activa y usa preservativo como método anticonceptivo. Hace dos semanas se realizó un test de embarazo en orina, que resultó negativo. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A Subunidad beta HCG
B Niveles plasmáticos de FSH
C Ecografía transvaginal
D Niveles plasmáticos de prolactina
E Niveles plasmáticos de TSH

Respuesta A. Estudio de la amenorrea: El estudio de la amenorrea debe comenzar descartando el embarazo. Aunque la paciente se realizó una prueba de embarazo en orina hace dos semanas, es recomendable iniciar el estudio con una nueva prueba de embarazo, antes de continuarla con TSH, prolactina y FSH (en la práctica se pide todo junto).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 115

Una mujer de 27 años, nulípara, usuaria de anticonceptivos orales por seis años, consulta por amenorrea de cinco meses de evolución, no asociado a otros síntomas. Su examen físico es normal. La conducta más adecuada en este caso es:

A Solicitar niveles de prolactina, tirotropina, hormona folículoestimulante y estrógenos

B Solicitar prueba de estrógeno y progesterona

C Indicar anticonceptivos orales combinados

D Observar evolución por un año

E Indicar uso de agonistas de las gonadotrofinas y controlar en un mes

Respuesta A. Prolactina, TSH es lo más importante. La FSH y estrógenos se piden después, pero es la opción más correcta. DE todos modos, el test de embarazo debería ser lo primero, luego TSH y PRL y luego la prueba de progesterona.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 89

Una paciente de 32 años consulta por amenorrea de 5 meses de evolución. Se realiza múltiples exámenes, entre los que destacan HCG: < 5 UL/L, FSH y LH < 5 UI/L, con pruebas tiroides y prolactina dentro de rangos normales. Su prueba de progesterona es negativa y su prueba de estrógeno más progesterona es positiva. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Síndrome de ovario poliquístico

B Falla ovárica primaria

C Síndrome de Asherman

D Falla hipotalámica / hipofisiaria

E Disgenesia gonadal

Respuesta D. PP negativa descarta anovulación (A); PE+P negativa confirma hipogonadismo; FSH y LH muy bajas muestran que es hipogonadotrópico y, por tanto, hipotalámico o hipofisiario. La B sería hipergonadotrópico. La C sería uterino, por lo que sus exámenes hormonales serían todos normales y tanto la PP como la PE+P estarían negativas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 113

Una paciente de 18 años consulta por amenorrea primaria. Refiere que inició su vida sexual hace algunos meses, pero presenta dolor durante la penetración. En su examen físico tiene desarrollo mamario y puberal normal, con genitales externos femeninos sin alteraciones. Se realiza especuloscopía y se observa vagina corta y estrecha, sin poder visualizar el cuello uterino. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Solicitar cariograma

B Solicitar ecogra:a pélvica

C Solicitar resonancia magné2ca nuclear de pelvis

D Solicitar niveles plasmá2cos de estrógeno, progesterona, FSH y LH

E Iniciar an2concep2vos orales

Respuesta B. Se debe estudiar con una ecografía pélvica, tanto por tener una amenorrea primaria (cuyo estudio inicia con ecografía), como por la vagina corta (que hace sospechar una agenesia mulleriana, que también se estudia con ecografía, la que muestra ausencia de útero). En caso de que no se identifique el útero, se sigue el estudio con cariograma, para diferenciar la agenesia mulleriana (46XX) de la insensibilidad a los andrógenos (46XY). Vale la pena mencionar que el desarrollo mamario y puberal...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 32

Una paciente de 36 años, multípara de 3, con historia de amenorrea desde hace 4 meses, no asociado a otros síntomas. Refiere haber sido usuaria de anticonceptivos orales hasta hace 6 meses y que se realizó test de embarazo en dos oportunidades con resultado negativo. Se solicitan niveles de hormona tiroestiumlante y prolactina que resultan normales, además prueba de progesterona que es negativa, por este motivo se solicita prueba de estrógeno más progesterona que resulta positiva y niveles de hormona folículo estimulante que resulta en 5 mUI/mL. El diagnóstico más probable es:

A Falla ovárica primaria

B Falla del eje hipotálamo hipofisiario

C Síndrome de ovario poliquístico

D Malformación uterina

E Síndrome de cushing

Respuesta B. Tiene un hipogonadismo (PP negativa, con PE+P positiva) hipogonadotrópico (FSH baja), por lo que es un problema hipotalámico (tendría GnRH baja) o hipofisiario (tendría GnRH alta).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 131

Una paciente de 15 años, con menarquia a los 14 años, consulta por atraso mens- trual de 2 meses. No tiene vida sexual. Su examen físico segmentario no muestra altera- ciones y tiene desarrollo mamario y genital acorde a su edad. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Pedir niveles plasmáticos de TSH y prolactina

B Solicitar ecografía transvaginal

C Realizar histerosonografía

D Iniciar anticonceptivos orales

E Dar progesterona oral, si el atraso dura un mes más

Respuesta E. Sería una amenorrea secundaria, probablemente por anovulación. Aunque nie- gue vida sexual, lo primero es un test de embarazo. Luego, en adolescentes, se hace la prueba de progesterona, si es que alcanza a hacer amenorrea de 3 meses. Sin embargo, no se debe olvidar que dentro de los 2 primeros años post menarquia es normal tener todo tipo de alteraciones menstruales.

▶ VER CLASE 3.01.1.013 **Cáncer cervicouterino** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.13 · Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Causado por VPH de alto riesgo (16 y 18): E6 y E7 inactivan p53 y Rb; progresión lenta desde lesión intraepitelial, por eso el tamizaje es eficaz.
- Sospecha clínica: sinusorragia (sangrado poscoital), metrorragia, leucorrea fétida en agua de lavar carne; al espéculo, lesión exofítica friable o úlcera que sangra al contacto.
- Con lesión visible no se repite el PAP: colposcopía con biopsia dirigida (problema de salud GES: confirmación y tratamiento con plazos garantizados).
- Etapificación FIGO clínica-imagenológica: IA–IIA1 (confinado al cuello) → cirugía radical (Wertheim-Meigs con linfadenectomía); IIB o más (parametrio) → quimiorradioterapia con cisplatino y braquiterapia.
- Manejo inicial: hemorragia aguda por tumor → taponaje vaginal y derivación urgente; no operar sin biopsia previa.
- Prevención: vacuna VPH nonavalente gratuita en 4.º y 5.º básico, PAP cada 3 años entre 25 y 64 años (GES). Seguimiento: derivar a oncología ginecológica.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 46 años, en control de salud sexual, refiere sangrado escaso después de las relaciones sexuales desde hace 2 meses. Su último Papanicolau, hace 8 meses, fue normal. Al examen con espéculo se observa una lesión exofítica friable de 1,5 cm en el labio anterior del cuello uterino, que sangra al contacto. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Repetir el Papanicolau en este momento

B Realizar colposcopía con biopsia dirigida de la lesión

C Solicitar tipificación de virus papiloma humano

D Indicar tratamiento antibiótico y controlar en un mes

E Programar histerectomía total sin biopsia previa

Respuesta B. Sinusorragia con una lesión exofítica friable visible al espéculo es cáncer cervicouterino hasta que se demuestre lo contrario. Con una lesión visible, el Papanicolau no aporta: se biopsia directamente en la colposcopía. La tipificación de VPH no cambia la conducta cuando ya hay una lesión visible, y operar sin biopsia previa es un error grave.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 177

Una paciente de 34 años consulta por genitorragia y sinusorragia, por lo que se realiza una especuloscopía, que muestra una lesión cervical ulcerada, friable. La conducta más adecuada es:

A Colposcopía y biopsia

B Conización cervical

C Seguimiento ecográfico

D Citología cervical

E Buscar virus papiloma humano

Respuesta A. Es un probable cáncer de cuello uterino. Se debe biopsiar, idealmente en la colposcopía (aunque también se puede biopsiar directamente). El PAP (citología) ya no sirve

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 33

Una paciente de 32 años se realizó un PAP hace dos años, que fue informado como "probable NIE 2", sin embargo no tuvo controles posteriores. Hace un mes comienza con genitorragia escasa e intermitente, asociada a mal olor genital. Se realiza una especuloscopía, que visualiza una lesión de 2 cm de diámetro, en relación al cuello uterino, ulcerada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Repetir el PAP en este momento
B Realizar biopsia de cuello uterino
C Realizar histerectomía radical
D Realizar un cono cervical
E Solicitar prueba de detección y tipificación de virus papiloma humano

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar biopsia de cuello uterino (opción B).

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 57

Mujer con PAP con NIE III hace 3 años, sin controles, ahora con lesión exofítica ulcerada en cuello uterino. ¿Cuál es la conducta?

A Colposcopía y tratamiento inmediato
B CONO diagnóstico-terapéutico
C Biopsia cervical
D Histerectomía total
E Repetir PAP y controlar en 3 meses

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Biopsia cervical (opción C). Biopsia cervical.

▶ VER CLASE 3.01.1.014 Dolor pelviano y dismenorrea

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.5 · Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Dismenorrea primaria: dolor cólico hipogástrico que inicia con la regla, desde 6–12 meses tras la menarquia, examen normal; por prostaglandinas.
- Dismenorrea secundaria: inicio tardío o progresiva, con dispareunia, sangrado anormal o infertilidad; sospechar endometriosis, adenomiosis, miomas, PIP crónico o DIU.
- Dolor pelviano crónico: >6 meses, no cíclico; descartar causas ginecológicas, urológicas (cistitis intersticial), digestivas (colon irritable) y musculoesqueléticas.
- Estudio inicial: examen ginecológico, beta-hCG, ecografía transvaginal; cultivos si hay flujo o sospecha de ITS.
- Tratamiento inicial primaria: AINE desde el inicio del dolor (ibuprofeno 400–600 mg c/8 h, naproxeno 550 mg) y/o anticonceptivos combinados; si no responde, pensar en endometriosis.
- Seguimiento: derivar a ginecología la dismenorrea secundaria, refractaria o con examen alterado (útero fijo, nódulos, masa anexial).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Adolescente de 16 años, menarquia a los 12 años, con ciclos regulares cada 28 días. Desde hace un año presenta dolor hipogástrico tipo cólico que comienza el primer día de la menstruación y dura 48 horas, con náuseas, que la obliga a faltar al colegio. No ha iniciado actividad sexual. No tiene dolor fuera de la menstruación ni dispareunia. Examen abdominal y ecografía pelviana transabdominal normales. **¿Cuál es el tratamiento de primera línea?**

A Laparoscopía diagnóstica
B Opioides en los días de dolor
C Análogos de GnRH
D Dienogest continuo
E Antiinflamatorios no esteroidales iniciados al comienzo del dolor o 1 a 2 días antes de la menstruación

Respuesta E. Dolor que coincide con la menstruación, desde poco después de la menarquia, con examen y ecografía normales: dismenorrea primaria, por exceso de prostaglandinas endometriales. La primera línea son los AINE (ibuprofeno, naproxeno, ácido mefenámico); si no responden o necesita anticoncepción, anticonceptivos combinados. La laparoscopía se reserva para la dismenorrea refractaria con sospecha de endometriosis.

▶ VER CLASE 3.01.1.015 Endometriosis

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.5 · Endometriosis y Adenomiosis: Tríada Cardinal, Diagnóstico y Manejo Médico Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Tríada: dismenorrea progresiva que no cede con AINE, dispareunia profunda e infertilidad (hasta 50%); también disquecia y disuria catameniales. Típica de mujer joven nulípara.
- Examen: útero en retroversión fija, nódulos dolorosos en el fondo de saco de Douglas y ligamentos uterosacros; teoría de la menstruación retrógrada (Sampson).
- Ecografía transvaginal: endometrioma con contenido homogéneo en vidrio esmerilado, sin papilas ni flujo Doppler; RM para enfermedad profunda; laparoscopía con biopsia es el estándar de oro.
- Sin deseo de embarazo: dienogest 2 mg/día continuo, ACO continuos o DIU-LNG; análogos de GnRH máximo 6 meses; AINE como coadyuvante.

- Busca embarazo: las hormonas no mejoran la fertilidad; derivar para cirugía conservadora o FIV. Cirugía si endometrioma ≥4 cm, dolor refractario o compromiso ureteral/intestinal.
- Diferencial con adenomiosis: multípara de 35–50 años, hipermenorrea, útero grande, blando y globoso. Seguimiento: derivar a ginecología.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 54

Mujer de 38 años con dismenorrea severa, dispareunia profunda y menometrorragia. La ecografía transvaginal muestra un útero aumentado de tamaño con ecotextura heterogénea, sin miomas definidos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Endometriosis
B Pólipo endometrial
C Hiperplasia endometrial
D Mioma uterino intramural
E Adenomiosis

Respuesta E. El útero aumentado de tamaño de forma difusa, con ecotextura heterogénea y sin miomas definidos, junto con menometrorragia y dismenorrea, es el cuadro clásico de adenomiosis: endometrio ectópico dentro del miometrio.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 10

Mujer de 32 años consulta por dismenorrea de 2 años, progresiva. Al examen ginecológico se palpa un tumor anexial derecho. La ecografía transvaginal muestra un tumor ovárico derecho de 6,5 cm, quístico, en vidrio esmerilado. Su Ca-125 resulta 86 UI/L (normal menor a 35). **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Carcinoma epitelial de ovario
B Endometrioma ovárico
C Teratoma maduro
D Disgerminoma ovárico
E Quiste folicular

Respuesta B. La imagen en vidrio esmerilado, en una mujer joven con dismenorrea progresiva, corresponde a un endometrioma ovárico. El Ca-125 elevado no descarta esto: también se eleva en procesos peritoneales benignos como la endometriosis, no solo en el cáncer.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 27 años, nuligesta, consulta por dismenorrea intensa de 3 años que ha empeorado progresivamente y no cede con ibuprofeno. Además tiene dispareunia profunda y lleva 18 meses buscando embarazo sin éxito. Al examen: útero en retroversión fija, con nódulos dolorosos en el fondo de saco de Douglas. La ecografía muestra en el ovario izquierdo un quiste de 4,2 cm con contenido homogéneo en vidrio esmerilado, sin papilas ni Doppler. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar dienogest 2 mg al día en forma continua
B Derivar a cirugía laparoscópica conservadora o a fertilización in vitro
C Indicar análogos de GnRH por 6 meses y reevaluar
D Iniciar anticonceptivos orales combinados en forma continua
E Controlar con ecografía en 6 meses, sin tratamiento

Respuesta B. El cuadro es endometriosis con endometrioma mayor a 4 cm, y la paciente busca embarazo desde hace 18 meses. El tratamiento hormonal no mejora la fertilidad y solo retrasa la búsqueda; la conducta es cirugía conservadora o derivación a técnicas de reproducción asistida.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 136

Paciente femenina 50 años aprox o 38 años (alguien recuerda?), tiene antecedente de esterilización y adenomiosis ¿Cual es el manejo? a. Histerectomía con preservación de ovarios

A Amoxicilina
B Ibuprofeno
C Paracetamol
D Omeprazol
E Metformina

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Amoxicilina (opción A).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 53

Mujer de 18 años consulta por dismenorrea secundaria, intensa, de 6 meses de evolución que ha aumentado progresivamente, por lo que ha tomado AINEs y paracetamol sin respuesta. Su examen físico y ginecológico son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Iniciar an2concep2vos orales

B Solicitar resonancia magné2ca nuclear de pelvis

C Realizar laparoscopía diagnós2ca

D Solicitar TAC de pelvis

E Realizar histeroscopía

Respuesta C. Es una pregunta muy discutible. La clínica orienta fuertemente a una endometriosis (dismenorrea secundaria, progresiva y refractaria), cuyo examen diagnóstico de elección es la laparoscopía (que también es terapéutica) y quien redactó la pregunta probablemente buscaba evaluar la capacidad de reconocer el cuadro clínico de la endometriosis. Sin embargo, aunque no está en las opciones, se recomienda iniciar el estudio con ecografía (que suele estar normal, salvo que haya un endometrioma) y...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 47

Una paciente de 35 años, usuaria de dispositivo intrauterino, hace 9 años, consulta por un cuadro de dolor pélvico, que aumentó en la última menstruación. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra una lesión quística de 6 cm en el ovario derecho, con contenido denso. Se solicitan niveles de Ca-125 que resultan 160 UI/ml (VN: menor a 35). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Quiste folicular

B Cáncer de ovario inicial

C Quiste endometriósico

D Cáncer de ovario avanzado

E Teratoma ovárico

Respuesta C. Diagnóstico: Quiste endometriósico (opción C). Es un endometrioma clásico, que también puede llamarse quiste endometriósico. Implantación de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina (peritoneo, ovarios, tabique recto-vaginal).

▶ VER CLASE 3.01.1.016 Enfermedad preinvasora del cuello uterino-Lesiones genitales intraepiteliales (NIE-HPV)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.13 · Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Lesiones intraepiteliales por VPH, asintomáticas; se pesquisan con el PAP (sistema Bethesda) y se confirman con colposcopía y biopsia.
- ASC-US o LIE de bajo grado en ≥30 años: test de VPH; si es 16/18 → colposcopía; si es negativo u otro genotipo, control en 6–12 meses. LIEBG (NIE I) regresa sola en la mayoría en 2 años.
- LIE de alto grado, ASC-H o AGC: colposcopía inmediata (GES: dentro de 30 días); AGC o sospecha de invasión se deriva sin observar.
- Colposcopía: zonas acetoblancas tras ácido acético y áreas yodonegativas en el test de Schiller orientan la biopsia.
- Tratamiento de NIE II–III: conización (LEEP o cono frío), diagnóstica y curativa si los márgenes son libres; no histerectomía de entrada.
- Manejo inicial del médico general: tomar PAP y derivar según resultado a la Unidad de Patología Cervical. Seguimiento: derivar (controles con PAP/VPH poscono).

PREGUNTAS · 13

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 91

Una paciente de 35 años, multípara de 1, se realiza PAP de control, que es informado como presencia de atipias escamosas de significado incierto (ASC-US). Su especuloscopía es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar colposcopía y biopsia cervical

B Solicitar reacción de cadena de polimerasa para virus papiloma humano

C Realizar diatermocoagulación cervical

D Realizar histerectomía

E Realizar biopsia de endometrio

Respuesta B. Ante un ASC-US, la conducta más aceptada es solicitar la prueba de VPH. Si resulta positiva para un genotipo de alto riesgo, se deriva a colposcopía y biopsia; si es negativa, se puede observar o repetir el PAP en 6 a 12 meses.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 21

Una paciente de 25 años, con antecedente de haber iniciado su vida sexual a los 14 años y mantener relaciones con múltiples parejas sin métodos de barrera, se realiza un PAP que es informado como lesión de alto grado. Además, se realiza tipificación de virus papiloma humano, que muestra serotipo de bajo grado. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar nuevo PAP en 6 meses

B Solicitar nuevo PAP en 6 años

C Realizar colposcopía y eventual biopsia

D Realizar conización cervical

E Realizar histerectomía

Respuesta C. El PAP de alto grado siempre se deriva a colposcopía y biopsia, sin importar el resultado de la tipificación de VPH: esa prueba solo cambia la conducta cuando el PAP es de bajo grado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 159

Una mujer tiene un PAP alterado, por lo que se realiza una colposcopía y biopsia, que es informada como lesión de bajo grado/VPH. ¿A qué evolucionará con mayor probabilidad esta lesión?

A Involución espontánea

B NIE 2

C Carcinoma in situ

D Condiloma acuminado

E Cáncer de cuello uterino

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Involución espontánea). Las NIE 1 en su mayoría involucionan espontáneamente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 11

PAP lesión de alto riesgo + VPH (+) 16 y 18: conducta

A Colposcopia y eventual biopsia (esta no es cono)

B Cono: según Guevara lesión de alto grado + VPH de alto grado es indicación de tratamiento al tiro (noo, LIE o VPH de alto grado son indicaciones por si solas de colpo + bx pero juntas no cambian la conducta, las únicas indicaciones de cono son NIE II, NIE III, Ca in situ y disociación colpocitológica)

C Amoxicilina

D Ibuprofeno

E Paracetamol

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Colposcopia y eventual biopsia (esta no es cono) (opción A).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 76

Una paciente de 30 años se realiza un PAP, que resulta atípico de alto grado, por lo que se realiza una colposcopía y biopsia, que es informada como NIE-1, de localización exocervical. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Seguimiento con PAP

B Crioterapia

C Cono cervical

D Tipificación de virus papiloma humano

E Diatermocoagulación

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Diatermocoagulación (opción E).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 60

Mujer de 34 años con PAP que informa células glandulares atípicas (AGC). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Colposcopía con biopsia dirigida y legrado endocervical

B Repetir PAP en 6 meses

C Histerectomía total

D Conización diagnóstica

E Cepillado endocervical y repetir PAP en 3 meses

Respuesta A. Células glandulares atípicas (AGC) en PAP tienen mayor riesgo de lesión endocervical o endometrial significativa. Conducta: colposcopía + biopsia + legrado endocervical para descartar adenocarcinoma.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 58

Mujer con PAP con NIE III y colposcopía normal con legrado endocervical normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Cono cervical
B Crioterapia cervical
C Seguimiento con PAP en 6 meses
D Histerectomía simple
E LEEP inmediato

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Cono cervical (opción A). Cono cervical.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 165

Una paciente se realiza un PAP, que es informado como probable lesión de bajo grado y presencia de virus papiloma humano. ¿Cuál es la conducta mas adecuada?

A Vacunar contra virus papiloma humano
B Realizar colposcopía y biopsia
C Repetir el PAP en 6 meses
D Realizar hibridación para serotipos oncogénicos de virus papiloma
E Realizar PAP en fase líquida en 1 a 3 meses

Respuesta B. Un PAP alterado, con probable lesión neoplásica, debe ir a colposcopía y biopsia, independiente del grado de las atipías celulares, más aún si hay VPH. La tipificación de VPH es cara, pero se recomienda, en caso de haber recursos (no es el caso de Chile), cuando hay una ASCUS (atipías celulares de significado incierto). La vacunación de VPH ya no sirve (se debe hacer antes de contraer el virus: en Chile se hace en 7° y 8° básico).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 112

Una paciente de 32 años, se realiza citología cervical, que es informada como “presencia de células escamosas atípicas, sugerentes de NIE 3”. Se realiza colposcopía que no muestra lesiones y curetaje endocervical que es informado como “tejido endocervical normal”. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Repetir el curetaje endocervical
B Controlar con nuevo Papanicolau en un año
C Realizar histerectomía
D Realizar conización cervical
E Realizar legrado y biopsia endometrial

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar conización cervical (opción D).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 173

Una paciente se realiza un PAP que muestra atipías escamosas de bajo grado. Se realiza una colposcopía y biopsia, que muestra presencia de una neoplasia intraepitelial grado 1 y un condiloma. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Crioterapia
B Tipificación de virus papiloma humano
C Conización cervical
D Histerectomía
E Curetaje endocervical

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Crioterapia (opción A). Tanto NIE 1, como condilomas, se tratan con crioterapia como primera línea.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 20

Una paciente de 24 años se realiza un PAP que es informado como probable lesión de bajo grado, por lo que se realiza una colposcopía, que muestra una neoplasia intraepitelial de bajo grado. La conducta más adecuada es:

A Controlar con PAP y colposcopía cada 6 meses
B Tratar con diatermocoagulación bipolar
C Tratar con crioterapia
D Realizar cono cervical con asa LEEP
E Realizar tratamiento con láser

Respuesta A. A y C son respuestas aceptables pata el manejo de una NIE 1; también la tipificación, al menos, según la guía Minsal. Sin embargo, lo más importante siempre es el control periódico de la paciente con un PAP alterado y, por eso, lo dejaremos como la respuesta correcta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 12

Disociación colpocitológica (PAP NIE III y colpo normal):

A Cono
B Volver a hacer legrado endocervical
C Repetir en 6 meses
D Ninguna de las anteriores es correcta
E Todas las anteriores son correctas

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Cono).

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 52

Una paciente de 24 años se realiza un PAP, que es informado como lesión de bajo grado y probable infección de virus papiloma humano. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar PAP en 1 año
B Realizar colposcopía y biopsia
C Repetir el PAP en 6 meses
D Realizar tipificación de virus papiloma humano
E Realizar PAP en 3 meses

Respuesta D. Es una pregunta discutible, ya que un PAP de bajo grado se puede controlar en 6 meses y también se puede tipificar el VPH: si es del ato grado (16 o 18), se envía a colposcopía; si es VPH de bajo grado, se observa y controla en 6 meses. Solo por la parte de la pregunta que dice "probable infección de VPH", nos inclinaremos por la opción de tipificarlo.

▶ VER CLASE 3.01.1.017

Enfermedades de transmisión sexual

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.9 · Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Úlceras genitales: sífilis primaria (chancro indoloro, indurado, adenopatía indolora) vs herpes (vesículas y úlceras múltiples dolorosas); confirmar con VDRL/RPR + treponémica o PCR.
- Sífilis primaria, secundaria o latente precoz: penicilina benzatina 2,4 millones UI IM dosis única (latente tardía: semanal x3); alérgicas no embarazadas: doxiciclina 100 mg c/12 h x14 días. Embarazada alérgica: desensibilizar.
- Uretritis/cervicitis (secreción purulenta, cuello friable): tratamiento dual empírico de gonococo + Chlamydia: ceftriaxona 500 mg IM dosis única + doxiciclina 100 mg c/12 h x7 días (azitromicina 1 g en embarazo).
- Tricomoniasis (flujo espumoso verdoso, cuello en fresa): metronidazol 2 g VO dosis única o 500 mg c/12 h x7 días; tratar siempre a la pareja. Herpes: aciclovir 400 mg c/8 h x7–10 días.
- Condilomas acuminados (VPH 6 y 11): podofilotoxina, imiquimod o crioterapia; prevención con vacuna VPH.
- Seguimiento completo: tratar a parejas, ofrecer VIH, VDRL, hepatitis B y C; control con VDRL cuantitativo (caída de 2 diluciones a los 6–12 meses); notificación obligatoria de sífilis y gonorrea.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 69

Una paciente de 25 años, embarazada, con 12 semanas contadas desde una FUR segura y confiable, se realiza exámenes, entre los que trae un VDRL que resulta no reactivo y un MHA-TP que resulta reactivo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Administrar penicilina benzatina de inmediato
B Realizar VDRL mensual durante el resto del embarazo
C Controlar con VDRL a las 30 semanas
D Solicitar un FTA-ABS
E Indicar doxiciclina vía oral

Respuesta C. Las pruebas no treponémicas (VDRL, RPR) se negativizan tras un tratamiento exitoso; las treponémicas (MHA-TP, FTA-ABS) quedan positivas de por vida. VDRL no reactivo con MHA-TP reactivo corresponde a una sífilis tratada en el pasado: se sigue el control prenatal habitual, con VDRL a las 28 a 30 semanas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 68

Una paciente de 31 años multípara de uno, cursando un embarazo de 34 semanas, sin patología previa, acude a control, objetivándose lesiones vaginales, que se muestran a continuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar cesárea electiva
B Aplicación local de podofilino
C Iniciar aciclovir oral
D Realizar tocaciones con ácido tricloroacético
E Inducir el parto en este momento

Respuesta D. Condilomas acuminados genitales en embarazo: La imagen muestra condilomas acuminados, causados por el virus del papiloma humano (VPH), serotipos 6 y 11. A diferencia del herpes genital, los condilomas acuminados no contraindican el parto vaginal. El tratamiento de elección durante el embarazo es el ácido tricloroacético tópico. Otros tratamientos tópicos como el imiquimod y el podofilino, aunque eficaces para tratar los condilomas acuminados, están contraindicados durante el embarazo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 46

Paciente de 29 años, cursando embarazo de 38 semanas, consulta por aparición de vesículas dolorosas a nivel vulvar, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecian vesículas con base eritematosa a nivel vulvar. El examen de elección para el diagnóstico etiológico en este caso es:

A Cultivo viral
B PCR para virus herpes
C Biopsia
D Inmunoglobulina G para virus herpes
E Tinción para virus herpes

Respuesta B. Pregunta mala. El diagnóstico es clínico y en la vida real no hay que pedir ningún examen y hacer cesárea. El gold standard siempre ha sido el cultivo viral, pero la PCR lo ha desplazado, por ser más rápida y más sensible. Yo marcaría PCR, pero el problema es que demora y hay que actuar de inmediato, por ser un embarazo y para decidir la vía de parto, lo único inmediato es la tinción de Tzank, aunque es un examen con mucho menor rendimiento. Sin embargo, no hay que rebuscarse y hay que...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 79

Una paciente, con antecedente de varias parejas sexuales, consulta por disuria inicial y leucorrea. En la especuloscopía se observa cuello uterino con cambios inflamatorios y abundante leucorrea amarillenta, sin otras alteraciones en el examen ginecológico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Vaginosis bacteriana
B Proceso inflamatorio pélvico
C Candidiasis urogenital
D Tricomoniasis
E Cervicitis gonocócica

Respuesta E. Diagnóstico: Cervicitis gonocócica (opción E). Es una cervicitis aguda clásica, cuyas causas más frecuentes son la gonorrea y la clamidia. Esta clase aborda las generalidades de las ETS y cubre uretritis, herpes genital y condiloma acuminado.

▶ VER CLASE `3.01.1.018` **Hemorragia genital anormal** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.3 · Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Sangrado uterino anormal: descartar primero embarazo (beta-hCG) y clasificar con PALM-COEIN (pólipo, adenomiosis, leiomioma, malignidad; coagulopatía, ovulatoria, endometrial, iatrogénica, no clasificada).
- Pólipo: sangrado intermenstrual; mioma submucoso: hipermenorrea; disfunción ovulatoria (SOP, extremos de la vida) es la causa no estructural más frecuente; en la adolescente con hipermenorrea, pensar en von Willebrand.
- Biopsia endometrial obligatoria (Pipelle) en ≥45 años con cualquier sangrado anormal, en toda metrorragia postmenopáusica con endometrio ≥4–5 mm, y en <45 con factores de riesgo (obesidad, SOP, tamoxifeno, Lynch).
- Estudio inicial: hemograma, TSH, prolactina si corresponde, ecografía transvaginal; perfil de coagulación si es adolescente con sangrado abundante.
- Tratamiento médico: DIU con levonorgestrel (el más eficaz), ácido tranexámico (no hormonal), AINE, anticonceptivos combinados o progestágenos; corregir anemia con hierro.
- Seguimiento: no requiere controles especializados si responde; derivar si hay causa estructural, sospecha de malignidad o falla del tratamiento.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 5

Una paciente de 48 años consulta por sangrado uterino, que no ha cesado desde su última menstruación, que inició hace dos semanas. Se solicita una ecografía transvaginal que muestra útero de tamaño normal, con endometrio de 19 mm de grosor y sin alteraciones anexiales. Su PAP, realizado hace poco, es normal, y su test de embarazo en orina es negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Histerectomía
B Ácido tranexámico endovenoso
C Estrógenos inyectables
D Anticonceptivos orales combinados
E Biopsia de endometrio

Respuesta E. Mujer de 48 años con endometrio muy engrosado en la ecografía: la biopsia endometrial es obligatoria antes de definir cualquier tratamiento hormonal, tanto por la edad como por el hallazgo ecográfico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 46

Una paciente de 55 años, con menopausia a los 51 años y usuaria de estrógenos transdérmicos como terapia de reemplazo hormonal, consulta por sangrado genital de 5 días de evolución. Al examen físico, sus signos vitales son normales y la especuloscopía no muestra sangrado activo ni lesiones del cuello uterino. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar histerectomía
B Aumentar la dosis de estrógenos
C Iniciar anticonceptivos orales
D Solicitar biopsia de endometrio
E Indicar ácido tranexámico vía oral

Respuesta D. Toda metrorragia en la postmenopausia se estudia. En usuarias de terapia de reemplazo hormonal el umbral ecográfico para biopsiar es más alto que en quien no la usa, pero cualquier sangrado igualmente obliga a descartar patología endometrial con biopsia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 85

Una paciente de 15 años consulta por hipermenorrea y menometrorragia. Se solicita una ecografía transvaginal, que no muestra lesiones ni alteraciones uterinas ni ováricas. El endometrio tiene 5 mm de grosor. Su hemograma muestra anemia leve, con glóbulos blancos y plaquetas normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar biopsia de endometrio
B Solicitar estudio de alteraciones de la hemostasia
C Solicitar estudio de trombofilias
D Solicitar resonancia magnética nuclear abdominopélvica
E Solicitar endosonografía uterina

Respuesta B. En una adolescente con hipermenorrea y ecografía sin causa anatómica, el paso siguiente es estudiar la hemostasia, buscando enfermedad de von Willebrand u otra coagulopatía. La biopsia de endometrio no tiene indicación a esta edad con endometrio delgado.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 46 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por 5 meses de menstruaciones abundantes con coágulos, cada 21 a 25 días. Hemoglobina de 10,1 g/dL. Especuloscopía normal. Ecografía transvaginal: útero de tamaño normal, miometrio homogéneo sin miomas, endometrio de 9 mm regular, sin imágenes focales. **¿Cuál es la conducta más adecuada antes de iniciar cualquier tratamiento hormonal?**

A Instalar un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel de inmediato
B Realizar biopsia de endometrio ambulatoria con cánula de Pipelle
C Indicar ácido tranexámico oral y controlar en 6 meses
D Realizar histerectomía total
E Observar con calendario menstrual por un año

Respuesta B. Toda mujer de 45 años o más con sangrado uterino anormal tiene indicación mandatoria de biopsia endometrial antes de definir un tratamiento hormonal, sin importar que la ecografía se vea tranquilizadora.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 53

Mujer de 22 años con ACO, metrorragia persistente 2 semanas y dolor hipogástrico hace 3 días, endometrio 15 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Solicitar β-HCG
B Ecografía transvaginal urgente
C Legrado uterino diagnóstico
D Suspender ACO y observar
E Solicitar hemograma y coagulación

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Solicitar β-HCG (opción A). Solicitar β-HCG.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 117

Mujer 43 años con sangrado intermenstrual sin dolor, activa sexualmente con preservativo, cómo continuar el estudio:

A BHCG y eco TV (este es el estudio inicial de todo SUA)

B TSH y T4

C FSH y LH

D Biopsia Yo puse biopsia QUE PUSIERON?, no convencía BHCG. Sg yo la beta era solo porque estaba en edad fertil pero igual hay que hacerle una eco si o si.

E Hemograma y VHS

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (BHCG y eco TV (este es el estudio inicial de todo SUA)).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 82

Una paciente de 31 años, usuaria de DIU desde hace 8 meses, consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de flujo menstrual muy abundante, asociado a escaso dolor abdominal. Se solicita hemograma, que muestra anemia con hemoglobina: 8,9 g/dl, VCM: 70 fl, HCM: 24 pg. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A Iniciar anticonceptivos orales

B Realizar biopsia de endometrio

C Iniciar ácido tranexámico

D Retirar el DIU

E Realizar ecografía transvaginal

Respuesta D. El DIU es causa de aumento del flujo menstrual y de dismenorrea. Se debe retirar y s epuede cambiar por un DIU medicado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 180

Mujer de 51 años consulta por metrorragia moderada de 10 días de evolución. Su última menstruación fue hace 6 meses. ¿Cuál es la causa mas probable de su hemorragia?

A Atrofia vaginal

B Hiperplasia endometrial

C Cáncer de endometrio

D Cáncer cervicouterino

E Metrorragia disfuncional FIN DEL EXAMEN La

Respuesta E. Por estar en el climaterio, es muy probable que sea disfuncional (es la causa más frecuente de metrorragia premenopausia). No aparecía atrofia endometrial como opción, sino atrofia vaginal, que está descartada.

▶ VER CLASE 3.01.1.019 Infecciones genitourinarias

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA

Ginecología 20.9 · Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis
Obstetricia 19.9 · Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Vaginosis bacteriana: flujo gris homogéneo con olor a pescado, sin inflamación; criterios de Amsel (3 de 4): flujo, pH >4,5, aminas (+), clue cells >20%. Metronidazol 500 mg c/12 h x7 días; no tratar a la pareja.
- Candidiasis: prurito intenso, flujo en leche cortada, pH normal (<4,5); fluconazol 150 mg VO dosis única; en embarazada clotrimazol vaginal x7 días (nunca fluconazol oral).
- Tricomoniasis: flujo espumoso verde-amarillento, cuello en fresa, pH alto; metronidazol 2 g dosis única y tratar a la pareja (es ITS).
- Bacteriuria asintomática (>100.000 UFC de un germen) y cistitis en la embarazada: tratar siempre, cefadroxilo 500 mg c/12 h x7 días (nitrofurantoína alternativa, evitar a término) y urocultivo de control 7–14 días después.
- Pielonefritis en el embarazo (fiebre >38,5, puñopercusión +): hospitalizar siempre, ceftriaxona o cefazolina EV hasta 48 h afebril, completar 14 días VO y profilaxis nocturna hasta el parto.
- Cistitis no complicada en no embarazada: nitrofurantoína 100 mg c/8–12 h x5 días o fosfomicina 3 g dosis única. Seguimiento completo: urocultivo de control y manejo de recurrencias.

PREGUNTAS · 13

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 121

Mujer de 28 años con dispareunia y flujo vaginal gris homogéneo con mal olor, que empeora tras el coito. El pH vaginal es de 5,5 y el test de aminas con KOH resulta positivo. **¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento más adecuado?**

A Vaginosis bacteriana: metronidazol oral 500 mg cada 12 horas por 7 días

B Candidiasis vaginal: fluconazol oral 150 mg dosis única

C Tricomoniasis: metronidazol 2 g dosis única

D Herpes genital: aciclovir

E Cervicitis por Chlamydia: azitromicina

Respuesta A. Flujo gris homogéneo, pH sobre 4,5 y test de aminas positivo: vaginosis bacteriana. Se trata con metronidazol oral 500 mg cada 12 horas por 7 días.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 178

Mujer de 26 años, sin antecedentes, consulta por secreción vaginal asociada a prurito. Al examen se aprecia liquenificación y signos de grataje vulvar, y a la especuloscopía, leucorrea blanquecina. **¿Cuál es el fármaco de elección para el manejo de este caso?**

A Metronidazol
B Fluconazol
C Miconazol
D Doxiciclina
E Ceftriaxona

Respuesta B. Prurito intenso con signos de rascado y leucorrea blanquecina: candidiasis genital. El fármaco de elección es fluconazol 150 mg oral en dosis única.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 117

Mujer de 30 años consulta por leucorrea y prurito. Al examen ginecológico destaca especuloscopía con leucorrea abundante, amarilla y espumosa. **¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico etiológico?**

A Prueba de aminas vaginales (test de KOH)
B Cultivo para Cándida albicans
C Examen de determinación de células clave (clue cells)
D Frotis fresco de la secreción vaginal
E PCR para Chlamydia trachomatis

Respuesta D. Flujo amarillo y espumoso: cuadro clásico de tricomoniasis. El diagnóstico se confirma con el frotis fresco, donde se ve el protozoo flagelado móvil.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 147

Mujer de 23 años, cursando un embarazo de 20 semanas, sin complicaciones, se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli multisensible, 60.000 UFC por mililitro. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Repetir el urocultivo en 2 semanas
B Iniciar cefradina vía oral
C Iniciar ciprofloxacino vía oral
D Solicitar ecografía
E Iniciar ceftriaxona endovenosa

Respuesta A. El corte para bacteriuria asintomática es cien mil colonias por mililitro; con sesenta mil, el urocultivo no la confirma. La conducta es repetirlo, no tratar todavía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 137

Paciente de 23 años, cursando un embarazo de 7 semanas, presenta un cuadro de disuria y polaquiuria, por lo que se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli sensible, con más de 100.000 UFC. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Cotrimoxazol
B Flucloxacilina
C Nitrofurantoína
D Levofloxacino
E Ciprofloxacino

Respuesta C. Cistitis en el primer trimestre: la nitrofurantoína es segura y de elección aquí; se evita solo entre las semanas 36 y 40. El cotrimoxazol se evita cerca del término, y las fluoroquinolonas están contraindicadas en todo el embarazo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 24 años, embarazada de 12 semanas, consulta por prurito vulvar intenso de una semana, con flujo blanco, espeso, en grumos, adherido a la pared vaginal. El pH vaginal es de 4,0 y el test de aminas resulta negativo. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Fluconazol 150 mg vía oral en dosis única
B Clotrimazol óvulos vaginales por 7 días
C Metronidazol 500 mg cada 12 horas por 7 días
D Metronidazol 2 g vía oral en dosis única, a ella y su pareja
E Ceftriaxona 500 mg intramuscular en dosis única

Respuesta B. El cuadro es candidiasis vulvovaginal (prurito, flujo en leche cortada, pH normal, aminas negativas). Por estar embarazada, el fluconazol oral se evita y se prefiere el azol tópico.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Embarazada de 18 semanas, sin ninguna molestia urinaria, trae el urocultivo de rutina de su control prenatal: 120.000 UFC por mililitro de Escherichia coli, sensible a cefadroxilo y nitrofurantoína. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A No tratar, porque está asintomática

B Indicar cefadroxilo oral por 7 días y urocultivo de control a las 1–2 semanas

C Hospitalizar para tratamiento endovenoso

D Indicar solo aumentar la ingesta de agua y controlar en un mes

E Repetir el urocultivo en 4 semanas, sin tratar por ahora

Respuesta B. Más de cien mil colonias de un solo germen, sin síntomas: bacteriuria asintomática. En el embarazo se trata siempre, con cefadroxilo oral por 7 días, y se confirma la erradicación con un urocultivo de control a los 7–14 días.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 32

Una paciente de 31 años de edad refiere mal olor genital, asociado a flujo, que empeora cuando tiene relaciones sexuales. Es usuaria de dispositivo intrauterino de cobre, desde hace 4 años. No tiene PAP vigente, por lo que se solicita un nuevo PAP, que resulta normal. En la especuloscopía se observa leucorrea de color gris, sin lesiones cervicales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Retirar el DIU bajo cobertura antibiótica

B Solicitar cultivo de secreción vaginal

C Indicar clindamicina tópica en óvulos

D Indicar clotrimazol tópico en óvulos

E Indicar fluconazol oral

Respuesta C. Vaginosis Bacteriana: El diagnóstico probable es vaginosis bacteriana, que se trata con metronidazol oral, siendo una alternativa la clindamicina tópica. No se debe confundir con la enfermedad inflamatoria pélvica que se presenta con dolor, flujo purulento y fiebre. El tratamiento para esta última condición consiste en antibióticos (orales o intravenosos según la gravedad) y la extracción del DIU si no hay respuesta en 48 horas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 116

Una paciente de 27 años, usuaria de dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, consulta por flujo genital de mal olor que empeora después de tener relaciones sexuales. Al examen físico se observa cuello uterino normal y secreción vaginal de color gris. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Retirar el dispositivo intrauterino bajo cobertura antibiótica

B Indicar fluconazol vía oral

C Iniciar doxiciclina vía oral

D Realizar VDRL a la paciente y a su pareja.

E Indicar metronidazol por vía oral

Respuesta E. Vaginosis Bacteriana y DIU: La paciente presenta un cuadro clínico compatible con vaginosis bacteriana, la cual se trata con metronidazol vía oral o clindamicina tópica. A diferencia del proceso inflamatorio pélvico que no responde al tratamiento antibiótico después de 48 horas, en la vaginosis bacteriana no es necesario retirar el DIU.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 34

Embarazada de 20 semanas con urocultivo positivo para E. coli sensible. Sin alergias. ¿Cuál es el antibiótico de elección para la infección urinaria en el embarazo?

A Cefalexina oral por 7 días

B Amoxicilina oral

C Cotrimoxazol (contraindicado en tercer trimestre)

D Ciprofloxacino (contraindicado en embarazo)

E Nitrofurantoína (evitar en tercer trimestre)

Respuesta A. ITU en embarazo: cefalexina oral 500 mg c/6-8h por 7 días es de primera línea en Chile. Ciprofloxacino: contraindicado (artropatía fetal). Cotrimoxazol: contraindicado en tercer trimestre (kernicterus). Nitrofurantoína: evitar en tercer trimestre. Cefalexina: segura en todos los trimestres.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 136

Pregunta 136 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente cursando un embarazo de 7 semanas de evolución, presenta prurito vaginal desde hace 7 días, con leucorrea de aspecto grumoso. Se realiza un cultivo vaginal, que muestra desarrollo de Streptococcus betahemolítico grupo B y Candida albicans. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A Clotrimazol tópico

B Ampicilina oral

C Azitromicina oral

D Fluconazol oral

E Clindamicina tópica

Respuesta A. Es una candidiasis y por estar embarazada, se prefiere el tratamiento tópico. De lo contrario, también habría sido correcto el fluconazol.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 176

Una paciente de 33 años, con antecedente de molestias urinarias, caracterizadas por disuria dolorosa, por lo que es diagnosticada de infección urinaria y tratada con ciprofloxacino oral, con buena respuesta clínica. Sin embargo, algunos días después reaparece el ardor al orinar y presenta prurito genital. Al examen físico se aprecia eritema de la mucosa vulvar, sin leucorrea y se observan erosiones lineales a nivel de la horquilla. El tratamiento más adecuado es:

A Cotrimoxazol
B Fluconazol
C Metronidazol
D Doxicilina
E Aciclovir

Respuesta B. Es una infección por Candida albicans, secundaria al uso de antibióticos, por tanto, se trata co fluconazol. Orientan a ello el prurito vaginal, la disuria y el compromiso de la horquilla. Eso sí, la ausencia de leucorrea inducía a la confusión, ya que habitualmente se pregunta con la infección más interna, con la leucorrea blanca grumosa clásica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 176

Una paciente cursa un embarazo de 24 semanas y es diagnosticada de infección urinaria baja, por Escherichia coli sensible, que se resuelve adecuadamente, luego de tratamiento antibiótico por 7 días. Tiene antecedente de una bacteriuria asintomática, tratada a las 16 semanas de embarazo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Solicitar urocultivo semanal
B Solicitar pielografía de eliminación
C Indicar aumento del consumo de agua
D Indicar nitrofurantoína a permanencia
E Indicar profilaxis, con jugo de cranberry

Respuesta D. La indicación de profilaxis antibiótica (con cefradina o nitrofurantoína) son 2 o más infecciones tratadas (independiente de si son bacteriurias asintomáticas, ITU baja, pielonefritis o mezclas de ellos).

▶ VER CLASE 3.01.1.020 Infertilidad conyugal

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.7 · Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida

QUÉ HAY QUE SABER

- Infertilidad: no lograr embarazo tras 12 meses de relaciones sin protección (6 meses si la mujer tiene ≥35 años); estudiar siempre a la pareja.
- Causas: factor masculino ~1/3, ovulatorio (SOP el más frecuente), tuboperitoneal (PIP, endometriosis), uterino y sin causa aparente.
- Estudio básico de 4 pilares: espermiograma primero (abstinencia 3–5 días, repetir a las 4–12 semanas si alterado); ovulación (progesterona día 21) y reserva (AMH, FSH día 3).
- Trompas: histerosalpingografía (prueba de Cotte positiva = permeable); útero: ecografía transvaginal e histeroscopía si hay defectos.
- Técnicas: inseminación intrauterina si hay al menos una trompa permeable y semen suficiente; FIV/ICSI en obstrucción bilateral, factor masculino severo, edad >38 o baja reserva.
- Manejo inicial: ácido fólico, suspender tabaco, normalizar peso y tratar causas simples (hipotiroidismo, hiperprolactinemia). Seguimiento: derivar a especialista en reproducción.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 108

Una paciente de 28 años acude a la clínica de fertilidad. Presenta reglas irregulares, que ocurren cada 2 a 3 meses. Al examen físico se observa obesa y tiene hirsutismo y acné, sin alteraciones en el examen ginecológico. Se solicita prueba de HOMA, que resulta normal, y una ecografía transvaginal que muestra útero normal, con ovarios poliquísticos. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado para lograr la fertilidad en esta paciente?**

A Espironolactona
B Análogos de la GnRH
C Citrato de clomifeno
D Metformina
E Progesterona

Respuesta C. Infertilidad por anovulación en el contexto de ovario poliquístico: se induce la ovulación. La metformina se reserva para pacientes con resistencia a la insulina comprobada, que aquí no está presente, ya que el HOMA es normal.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Pareja de 31 y 33 años consulta por no lograr embarazo tras 18 meses. Ella tiene ciclos regulares y progesterona en día 21 ovulatoria. La histerosalpingografía muestra cavidad uterina normal, pero ausencia completa de paso de contraste por ambas trompas, con hidrosálpinx bilateral y prueba de Cotte negativa. El espermiograma de él es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Inseminación intrauterina con semen del cónyuge

B Inducción de ovulación con citrato de clomifeno

C Fertilización in vitro

D Repetir la histerosalpingografía en 3 meses

E Antibioticoterapia prolongada con doxiciclina

Respuesta C. La obstrucción tubárica bilateral confirmada con Cotte negativa hace imposible el encuentro entre óvulo y espermatozoide, aunque el semen y la ovulación sean normales. La inseminación está contraindicada; la conducta es derivar a fertilización in vitro.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 149

Una pareja joven consulta por infertilidad, refieren que llevan 15 meses intentando tener hijos pero no han tenido resultado, ambos no tienen hijos anteriormente. El hombre trae consigo espermiograma que se realizó hace dos semanas que está normal. Ella nunca ha utilizado anticonceptivos orales y refiere ciclos menstruales normales, su examen físico resulta normal. El examen de elección para continuar el estudio de infertilidad en este caso es:

A Repetir espermiograma

B Test post coital

C Laparoscopía

D Histeroscopía

E Histerosalpingografía

Respuesta B. De elección es el seguimiento folicular, que no está dentro de las alternativas. El test postcoital requiere de un seguimiento folicular y se le pide que tengan relaciones el día previo a la ovulación (se sabe ese día por el Seguimiento folicular ecográfico), de modo de evaluar el factro cervical además. Los demás exámenes son de segunda o tercera línea

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 109

Una paciente de 30 años, con un hijo de 5 años con otra pareja, consulta por infertilidad de 3 años con su nueva pareja. Ella cuenta con estudio hormonal normal y él tiene un espermiograma sin alteraciones. La conducta más adecuada es:

A Realizar cariograma

B Repetir el espermiograma

C Solicitar fragmentación de ADN espermático

D Realizar laparoscopía diagnóstica

E Realizar histerosalpingografía

Respuesta E. El estudio de la infertilidad siempre es de la pareja y no importa si tienen hijos de antes. El hombre solo se estudia con espermiograma. La mujer se estudia con exámenes por etapas: la primera línea es el seguimiento folicular con ecografías seriadas y exámenes hormonales; de segunda línea se pide la histerosalpingografía (busca alteraciones tubepritoneales); de tercera línea se hace la laparoscopía exploradora, en busca de endometriosis.

▶ VER CLASE 3.01.1.021 **Mioma uterino** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.4 · Patología Benigna Uterina: Miomatosis Uterina (FIGO 0-8) y Adenomiosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumor benigno de músculo liso más frecuente del aparato genital; más de la mitad son asintomáticos (hallazgo ecográfico).
- Clasificación FIGO por ubicación: submucoso (el que más sangra y causa infertilidad), intramural y subseroso (da síntomas compresivos: polaquiuria, constipación, dolor pélvico).
- Confirmación: ecografía transvaginal (nódulo hipoecogénico bien delimitado); histerosonografía o histeroscopía para submucosos. Si hay sangrado postmenopáusico con endometrio grueso, biopsiar: no atribuirlo al mioma.
- Manejo inicial: asintomático → observación con control ecográfico; sangrado → ácido tranexámico, AINE, DIU-LNG y hierro; análogos de GnRH solo como puente prequirúrgico.
- Quirúrgico: miomectomía si desea fertilidad (histeroscópica en submucoso); histerectomía con paridad cumplida o anemia refractaria.
- Embarazo: degeneración roja (dolor agudo, fiebre baja, leucocitosis) se maneja con reposo, hidratación y analgesia, no se opera. Crecimiento rápido en postmenopausia: sospechar sarcoma. Seguimiento: control ecográfico periódico y clínico.

PREGUNTAS · 9

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 51

Una paciente de 35 años, nulípara, consulta por una historia de un año de flujo menstrual abundante y, en ocasiones, flujo intermenstrual escaso. Usa preservativo como método anticonceptivo. Trae hemograma con hemoglobina de 10,5 mg/dL, hematocrito de 31 %. Se realiza ecografía transvaginal, que demuestra presencia de un mioma submucoso de 2 cm de diámetro. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Histerectomía total

B Resonancia magnética nuclear de pelvis

C Observar evolución

D Miomectomía histeroscópica

E Resección del mioma por laparoscopía

Respuesta D. Mioma submucoso sintomático, con anemia asociada, en mujer nulípara: el tratamiento de elección es la miomectomía histeroscópica, que resuelve el sangrado conservando el útero y la fertilidad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 151

Una paciente de 43 años, multípara de 4, consulta porque se ha sentido más cansada de lo normal, con disnea de grandes esfuerzos. Sus reglas son abundantes. Hemoglobina de 8 g/dL, hematocrito de 23 %, con hipocromía y microcitosis. Ecografía transvaginal: múltiples miomas intramurales de hasta 5 cm, más un mioma submucoso de 4 cm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar histeroscopía

B Realizar histerectomía total

C Administrar análogos de la GnRH

D Iniciar anticonceptivos orales

E Antifibrinolíticos

Respuesta B. Miomatosis sintomática con anemia severa en una mujer con paridad cumplida (multípara de 4): el tratamiento curativo definitivo es la histerectomía total.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 43

Una paciente de 56 años, usuaria de terapia de reemplazo hormonal y sin síntomas ginecológicos, se realiza una ecografía abdominal durante el estudio de un cuadro de constipación crónica. En dicho examen se detecta un mioma uterino subseroso de 32 por 35 mm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar laparoscopía

B Suspender la terapia de reemplazo hormonal

C Iniciar anticonceptivos orales

D Realizar histerectomía

E Realizar control ecográfico en 6 meses

Respuesta E. Mioma asintomático, hallazgo incidental en una ecografía pedida por otro motivo: la conducta es la observación con control ecográfico, sin importar su clasificación FIGO.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 41 años, multípara de 3 con paridad cumplida, consulta por menstruaciones muy abundantes con coágulos desde hace 8 meses, con astenia progresiva. Hemoglobina de 8,5 g/dL. Ecografía transvaginal: útero de tamaño equivalente a 10 semanas, con dos miomas intramurales de 5 y 6 cm que no contactan la cavidad endometrial. Biopsia de endometrio: proliferativo, sin atipias. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A Miomectomía histeroscópica

B Histerectomía total

C Análogos de GnRH de forma indefinida

D Observación con control ecográfico anual

E Dispositivo intrauterino de cobre

Respuesta B. Miomatosis sintomática con anemia severa, biopsia endometrial ya benigna y paridad cumplida: el tratamiento curativo definitivo es la histerectomía total. La miomectomía histeroscópica no aplica porque los miomas son intramurales, sin contacto con la cavidad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 63

Una paciente de 30 años, nulípara, consulta por presentar reglas abundantes, asociado a astenia e hipersomnia. Al examen físico destacan mucosas pálidas, sin otros hallazgos. Se realiza hemograma donde destaca hemoglobina que resulta en 8mg/dL, y además se realiza ecografía transvaginal que muestra presencia de dos miomas intramurales. El tratamiento de elección en este caso es:

A Anticonceptivos orales

B Agonistas de las gonadotrofinas

C Histerectomía

D Miomectomía

E Observación

Respuesta D. Miomas sintomáticos en mujer sin hijos: miomectomía. Cierto es que los miomas intramurales suelen ser asintomáticos, pero en este caso se debe simplificar la pregunta a ¿cuál es el tratamiento de los miomas con hipermenorrea?

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 162

Una paciente de 53 años acude a control ginecológico. Tuvo su menopausia a los 51 años y está en terapia de reemplazo hormonal, con estrógeno y progestágeno por vía oral, como tratamiento de los síntomas vasomotores del climaterio. Su examen ginecológico es normal, al igual que su mamografía y PAP. Además, se solicita una ecografía transvaginal, cuya imagen se presenta a continuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar biopsia endometrial

B Controlar con ecogra:a en 6 meses

C Suspender la terapia de reemplazo hormonal

D Realizar resección de la lesión por laparoscopía

E Instalar disposi2vo intrauterino medicado con levonorgestrel

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Controlar con ecogra:a en 6 meses (opción B). Tiene un mioma asintomático, por lo que se debe observar evolución. Fuente imagen: hxps://we.riseup.net/assets/230674/..

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 154

Una paciente de 50 años consulta por amenorrea de 8 meses de evolución. Se realiza ecografía transvaginal que muestra múltiples imágenes nodulares, hipoecogénicas intramurales y subserosas de hasta 3 cm. La indicación más adecuada es:

A Histerectomía

B Ecografía en 6 meses

C Terapia de reemplazo hormonal

D Análogos de la GnRH

E Biopsia por histeroscopía

Respuesta B. Tiene miomas asintomáticos (la amenorrea no es síntoma de miomas), por lo que se observan. Además, por estar en amenorrea a los 50 años, probablemente esté menopáusica y, con ello, los miomas tienden a involucionar (aunque da igual en realidad).

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 79

Una paciente de 35 años, multípara de dos, se realiza una cesárea por presentación podálica. Luego de la extracción del recién nacido y del legrado uterino, se observan múltiples miomas uterinos subserosos de variados tamaños. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar miomectomía múltiple

B Realizar histerectomía subtotal

C Realizar miomectomía selectiva de los tumores mayores a 5 cm

D Realizar histerectomía obstétrica

E Realizar el cierre habitual de la cesárea

Respuesta E. Los miomas asintomáticos (en este caso simple hallazgo en la cesárea) no requieren tratamiento alguno.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 166

Una mujer de 53 años, con antecedente de reglas irregulares, está en amenorrea desde hace 9 meses. Su examen ginecológico es normal y cuenta con mamografía y Papanicolau recientes, sin alteraciones. Se realiza una ecografía transvaginal que muestra endometrio fino y miometrio con múltiples nódulos hipoecogénicos subserosos y transmurales de entre 2 y 4 cm de diámetro. La indicación más adecuada es:

A Histerectomía total

B Tumorectomía

C Análogos de GnRH

D Anticonceptivos orales

E Observar evolución

Respuesta E. Tiene un climaterio y probable menopausia (cuando cumpla 12 meses de amenorrea se hará el diagnóstico de menopausia). La presencia de miomas asintomáticos es un hallazgo ecográfico sin importancia.

▶ VER CLASE | 3.01.1.022 | **Oligoanovulación crónica** | DX SOSPECHA | TX INICIAL | SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.2 · Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Oligoanovulación: ciclos >35 días u oligo/amenorrea; la causa más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico; también hiperprolactinemia, hipotiroidismo e hipotalámica funcional.
- SOP por criterios de Rotterdam (2 de 3): oligo/anovulación, hiperandrogenismo clínico (hirsutismo, acné) o bioquímico, y morfología poliquística ecográfica.
- Antes de confirmar: descartar embarazo y pedir TSH, prolactina y 17-OH-progesterona (hiperplasia suprarrenal no clásica); evaluar resistencia insulínica (glicemia, PTGO) y lípidos.
- Riesgo de la anovulación crónica: endometrio expuesto a estrógeno sin oposición → hiperplasia y cáncer de endometrio; asocia síndrome metabólico y DM2.
- Manejo inicial: bajar 5–10% del peso; sin deseo de embarazo → ACO con progestágeno antiandrogénico (ciproterona, drospirenona) o progestágeno cíclico; metformina si hay resistencia insulínica.
- Con deseo de embarazo: inducción de ovulación con letrozol (primera línea) o clomifeno. Seguimiento: derivar a ginecología/endocrinología ginecológica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 23 años, con sobrepeso, consulta por reglas cada 50 a 60 días desde la menarquia y acné facial persistente. Al examen: vello grueso en mentón y línea alba, puntaje de Ferriman-Gallwey de 11. Ecografía transvaginal: ambos ovarios con múltiples folículos periféricos pequeños. No desea embarazo en este momento. **¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?**

A Citrato de clomifeno
B Anticonceptivos orales combinados con progestágeno antiandrogénico
C Análogos de GnRH
D Metformina en monoterapia, sin anticonceptivos
E Danazol oral continuo

Respuesta B. Cumple dos criterios de Rotterdam: oligomenorrea y ecografía con morfología poliquística, más hiperandrogenismo clínico. Sin deseo de embarazo, el tratamiento de elección son los anticonceptivos combinados con progestágeno antiandrogénico.

▶ VER CLASE 3.01.1.023 Patología benigna del endometrio (hiperplasia, pólipos...)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.3 · Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Pólipo endometrial: causa estructural más frecuente de sangrado intermenstrual; también metrorragia postmenopáusica. Ecografía: engrosamiento focal; histerosonografía o histeroscopía confirma.
- Hiperplasia endometrial: por estrógeno sin oposición (obesidad, SOP/anovulación, tamoxifeno, TRH sin progestágeno); se manifiesta como sangrado uterino anormal.
- Sospecha: sangrado anormal en ≥45 años, metrorragia postmenopáusica con endometrio ≥4–5 mm (≥8 mm con TRH) o <45 años con factores de riesgo → biopsia con Pipelle.
- La hiperplasia con atipia (neoplasia intraepitelial endometrial) tiene alto riesgo de coexistir o progresar a cáncer: histerectomía si la paridad está cumplida.
- Hiperplasia sin atipia: progestágenos (DIU-LNG de elección u orales) y control con biopsia; pólipo sintomático o postmenopáusico: polipectomía histeroscópica.
- Manejo inicial del médico general: estudiar con ecografía, corregir anemia y derivar. Seguimiento: derivar a ginecología.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 49

Mujer con sangrado intermenstrual. La ecografía muestra un pólipo endometrial de 15 mm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Legrado uterino diagnóstico-terapéutico
B Anticonceptivos orales para control del sangrado
C Seguimiento ecográfico en 6 meses
D Realizar histeroscopia
E Histerectomía

Respuesta D. El pólipo endometrial es la causa estructural (P de PALM-COEIN) más frecuente de sangrado intermenstrual, y su manejo de elección es la resección guiada por histeroscopía, que además permite el estudio histológico completo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 120

Una paciente de 68 años, nulípara, con antecedente de menopausia a los 50 años, consulta debido a sangrado genital intermitente de 2 meses de evolución, con cuantía variable. Se realiza una ecografía transvaginal que muestra un endometrio de 13 mm de grosor de aspecto heterogénea, con áreas microquísticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Hiperplasia endometrial
B Miomatosis endometrial
C Atrofia endometrial
D Pólipo endometrial
E Cáncer de endometrio

Respuesta A. Hiperplasia Endometrial: El endometrio grueso e irregular es una característica tanto de la hiperplasia endometrial como del cáncer de endometrio. Sin embargo, la descripción de un aspecto heterogéneo con áreas microquísticas se observa con mayor frecuencia en la hiperplasia endometrial, por lo que esta es la respuesta correcta. Eso sí, la conducta es realizar una biopsia de endometrio para confirmar el diagnóstico y descartar el cáncer. La hiperplasia simple se trata con progestágenos. La...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 124

Pcte de 39 años con metrorragia e hipermenorrea, eco con endometrio homogéneo y masa en fondo uterino, conducta:

A histeroscopia (segun yo tmbn x4, obs pólipo endometrial)

B biopsia endometrial

C Observación clínica

D Derivar a urgencia

E Control ambulatorio

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: histeroscopia (segun yo tmbn x4, obs pólipo endometrial) (opción A).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 37

Una paciente de 35 años, nulípara, sin antecedentes mórbidos de importancia, consulta porque desde hace 6 meses ha presentado aumento del flujo menstrual. Su examen físico no aporta mayor información. Tiene PAP sin presencia de células atípicas, realizado hace 8 meses. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra la presencia de un pólipo endometrial de 8 mm de diámetro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar histerosonografía

B Realizar histerectomía

C Realizar histeroscopía

D Realizar legrado uterino

E Iniciar anticonceptivos orales

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar histeroscopía (opción C).

▶ VER CLASE 3.01.1.024 Patología maligna del endometrio

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.15 · Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

QUÉ HAY QUE SABER

- Sangrado postmenopáusico es cáncer de endometrio hasta demostrar lo contrario; es su síntoma cardinal (presente en >90%).
- Tipo I (80%, endometrioide, estrógeno-dependiente, buen pronóstico): obesidad (el factor más potente), nuliparidad, SOP/anovulación, tamoxifeno, diabetes, síndrome de Lynch. Tipo II (seroso, células claras): mujeres mayores, agresivo.
- Estudio: ecografía transvaginal; endometrio ≥4–5 mm (≥8 mm con TRH) → biopsia con Pipelle; si es insuficiente o no concluyente → histeroscopía con biopsia dirigida.
- Confirmado: TAC de tórax, abdomen y pelvis y cirugía etapificadora (histerectomía total + salpingooforectomía bilateral + ganglio centinela o linfadenectomía); adyuvancia según estadio.
- Lynch: tamizaje anual desde los 30–35 años y cirugía profiláctica a los 40 con paridad cumplida.
- Manejo inicial: si sangra abundante, estabilizar; derivar a ginecología oncológica. Seguimiento: derivar.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 81

Una paciente de 56 años, en tratamiento con tamoxifeno 20 mg al día por un cáncer de mama diagnosticado hace 9 años, presenta metrorragia escasa desde hace 5 días, por lo que se solicita una ecografía transvaginal, que muestra un endometrio de 8 mm, sin alteraciones anexiales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar terapia de reemplazo hormonal oral

B Instalar dispositivo intrauterino medicado

C Disminuir la dosis de tamoxifeno

D Solicitar biopsia endometrial

E Realizar histerectomía

Respuesta D. El tamoxifeno actúa como estrógeno en el endometrio y sube el riesgo de hiperplasia y cáncer endometrial. Con metrorragia postmenopáusica y un endometrio de 8 mm, la conducta es biopsiar, no ajustar el tamoxifeno ni operar sin diagnóstico previo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 58 años, con menopausia hace 7 años, sin terapia de reemplazo hormonal, consulta por un sangrado genital escaso de 10 días de evolución. La ecografía transvaginal muestra un endometrio de 9 mm, heterogéneo, con anexos normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar estrógenos vaginales y controlar en 3 meses

B Realizar biopsia endometrial ambulatoria con cánula de Pipelle

C Solicitar resonancia magnética de pelvis

D Indicar reposo y observar la evolución

E Programar histerectomía sin estudio previo

Respuesta B. Sangrado postmenopáusico con endometrio de 9 mm, muy por encima del corte de 4 a 5 mm sin TRH: se biopsia de inmediato con cánula de Pipelle. Los estrógenos, el reposo o la observación retrasan un diagnóstico posible de cáncer, y operar sin biopsia previa es un error grave.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 178

Una mujer de 65 años, nulípara, con IMC de 33, sin síntomas, se realiza un PAP que muestra abundantes células endometriales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Controlar con nuevo PAP en un año
B Indicar estrógenos tópicos
C Solicitar colposcopía y biopsia
D Realizar curejate endocervical
E Solicitar ecografía transvaginal

Respuesta E. Tiene factores de riesgo de cáncer de endometrio (obesidad y nuliparidad) y además células endometriales. Se debe descartar una hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio, partiendo por la Eco.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 166

Paciente de 40 y tantos años con uso de ACO, suspendidos hace 2 semanas por gastritis. Inicia con sangrado hace 3 días?, eco con endometrio de 10 mm heterogéneo. Conducta más adecuada:

A Suspender ACO y controlar en 3 meses
B Legrado biópsico en pabellón
C Biopsia aspirativa de forma ambulatoria.
D Interrupción del embarazo
E Maduración pulmonar y observación

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Suspender ACO y controlar en 3 meses (opción A).

▶ VER CLASE 3.01.1.025 Proceso inflamatorio pelviano

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.11 · Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Infección ascendente por gonococo o Chlamydia (y flora polimicrobiana): endometritis → salpingitis → peritonitis pélvica → absceso tubo-ovárico.
- Criterios de Hager: los 3 mayores (dolor abdominal bajo, dolor a la movilización cervical, dolor anexial) + al menos 1 menor (fiebre >38,3 °C, leucorrea patológica, PCR/leucocitos altos, cultivo positivo).
- Estudio: beta-hCG (descartar ectópico), ecografía transvaginal (absceso), hemograma, PCR, cultivos; ante la sospecha clínica no retrasar el tratamiento.
- Ambulatorio (Monif I–II sin gravedad): ceftriaxona 500 mg IM dosis única + doxiciclina 100 mg c/12 h + metronidazol 500 mg c/12 h VO por 14 días; tratar a la pareja.
- Hospitalizar si: absceso tubo-ovárico, embarazo, peritonitis difusa, falta de respuesta o intolerancia oral, duda diagnóstica; esquema EV (o clindamicina + gentamicina).
- Secuelas: infertilidad tubaria, ectópico, dolor pelviano crónico; Fitz-Hugh-Curtis (dolor en hipocondrio derecho). El DIU solo aumenta el riesgo el primer mes. Seguimiento: derivar a ginecología.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 152

Mujer de 25 años, sexualmente activa, sin métodos de barrera, con fiebre, dolor abdominal, disuria, polaquiuria y leucorrea. Temperatura 38 grados, dolor a la palpación abdominal mayor en la fosa ilíaca derecha, leucorrea y dolor a la palpación bimanual. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Escherichia coli
B Gardnerella vaginalis
C Trichomona vaginalis
D Estreptococo grupo A
E Gonococo

Respuesta E. Cuadro clínico de enfermedad pélvica inflamatoria (fiebre, dolor abdominal bajo y dolor a la palpación bimanual): el agente etiológico clásico es el gonococo, junto con Chlamydia trachomatis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 174

Mujer de 26 años, sexualmente activa, consulta por disuria y dolor abdominal bajo que luego se extiende al hipocondrio derecho, con leucorrea. Al examen hay dolor a la palpación hipogástrica y del hipocondrio derecho, y en el examen ginecológico se constata leucorrea, sin mal olor. **¿Cuál es el agente etiológico más probable?**

A Enterococcus faecalis
B Ureaplasma urealyticum
C Chlamydia trachomatis
D Treponema pallidum
E Mycoplasma genitalium

Respuesta C. Dolor pélvico que se extiende al hipocondrio derecho: síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, complicación de la enfermedad pélvica inflamatoria causada habitualmente por Chlamydia trachomatis o gonococo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 23 años, sexualmente activa, con dolor en hipogastrio de 3 días, fiebre de 38,6 grados y flujo purulento. Al tacto bimanual hay dolor a la movilización cervical y dolor anexial bilateral, sin masas. La ecografía transvaginal no muestra colecciones y el test de embarazo es negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Hospitalizar para tratamiento endovenoso

B Laparoscopía exploradora de urgencia

C Ceftriaxona intramuscular más doxiciclina y metronidazol orales por 14 días

D Solo doxiciclina oral por 7 días

E Retirar el DIU y esperar evolución

Respuesta C. Se cumplen los tres criterios mayores de Hager, con un criterio menor (fiebre), sin masas ni signos de gravedad: EIP estadio I-II de Monif, de manejo ambulatorio con el esquema triple durante 14 días.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 80

Una paciente de mantiene actividad sexual, sin método anticonceptivo, consulta por fiebre, asociada a dolor abdominal de 3 días de evolución. Al examen físico presenta abdomen sensible y al examen ginecológico destaca útero doloroso, tanto a la palpación, como a la movilización. Se solicitan exámenes, que muestran test de embarazo negativo, hemograma con leucocitos: 18.000 por campo y PCR: 8,0 mg/L. La ecografía transvaginal muestra presencia de líquido libre escaso en la cavidad peritoneal, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

A Iniciar tratamiento sintomático con ácido mefenámico

B Realizar cultivo endocervical

C Indicar anticonceptivos orales

D Iniciar tratamiento antibiótico

E Realizar laparotomía exploradora

Respuesta D. Tiene un proceso inflamatorio pélvico, no complicado, por lo que se trata con antibióticos de amplio espectro.

▶ VER CLASE 3.01.1.026 Prolapso genital

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.6 · Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Prolapso de órganos pélvicos: descenso de pared anterior (cistocele), apical (útero/cúpula) o posterior (rectocele) por daño del piso pélvico.
- Factores de riesgo: partos vaginales traumáticos (fórceps, RN grandes), multiparidad, menopausia (hipoestrogenismo), obesidad, constipación y tos crónica.
- Sospecha: sensación de bulto o peso vaginal que empeora de pie o al final del día, dificultad miccional o defecatoria, que a veces requiere reducción manual.
- Clasificación POP-Q con el himen como punto 0: estadio 2 entre 1 cm sobre y 1 cm bajo el himen; estadio 4, eversión completa.
- Manejo inicial: ejercicios de Kegel, control de peso y constipación, estrógeno vaginal en atrofia; pesario si no desea o no tolera cirugía.
- Seguimiento: derivar a ginecología (uroginecología) para cirugía en prolapsos sintomáticos (colporrafia, histerectomía vaginal, sacrocolpopexia).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 45

Mujer de 58 años, multípara de 4, presenta sensación de peso vaginal, asociada a escapes de orina al inicio del deseo miccional. Al examen físico presenta prolapso genital. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar oxibutinina oral

B Realizar prueba de Q-tip

C Realizar la estadificación POP-Q

D Solicitar resonancia magnética pelviana

E Realizar histerectomía

Respuesta C. Ante un prolapso genital confirmado al examen, el paso siguiente es cuantificarlo formalmente con el sistema POP-Q, que mide cada compartimento tomando el himen como plano de referencia. Recién con esa estadificación se decide el tratamiento.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 143

Una mujer de 87 años, es institucionalizada por una demencia tipo Alzheimer. Al examen físico del ingreso se aprecia lo siguiente: INSERTAR FOTO ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar cirugía de urgencia

B Realizar PAP y colposcopía

C Indicar pesario

D Realizar biopsia

E Cuidados paliativos

Respuesta C. Era un prolapso uterino completo. Si fuera una mujer sana, se haría cirugía electi- va (no de urgencia), pero dado que era una paciente con alzheimer avanzado, se puede dejar pesario.

▶ VER CLASE 3.01.1.027 **Síndrome climatérico y menopausia** DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.12 · Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos

QUÉ HAY QUE SABER

- Menopausia: diagnóstico clínico tras 12 meses de amenorrea en mujer >45 años; no pedir FSH de rutina (solo si se sospecha insuficiencia ovárica antes de los 40).
- Síntomas: corto plazo bochornos, sudoración nocturna, insomnio y cambios del ánimo; mediano plazo síndrome genitourinario (sequedad, dispareunia, disuria); largo plazo osteoporosis y riesgo cardiovascular.
- TRH en síntomas que alteran la calidad de vida dentro de la ventana de oportunidad (<60 años o <10 años de menopausia): con útero, estrógeno + progestágeno obligatorio; histerectomizada, estrógeno solo.
- Contraindicaciones: cáncer de mama o endometrio, trombosis o evento cardiovascular, enfermedad hepática activa, sangrado uterino no estudiado.
- Alternativas no hormonales para bochornos: venlafaxina, paroxetina (no con tamoxifeno), gabapentina; atrofia vaginal: estrógeno vaginal local y lubricantes.
- Seguimiento completo: control anual con PA, peso, perfil lipídico, glicemia, mamografía, PAP y densitometría según riesgo; reevaluar la TRH cada año y usar la menor dosis eficaz.

PREGUNTAS · 17

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 78

Mujer de 52 años con reglas irregulares desde hace 8 meses, asociadas a bochornos frecuentes, con calor, enrojecimiento de la cara, sudoración nocturna y dificultad para dormir. **¿Cuál es la indicación más adecuada para el manejo de sus síntomas?**

A Fitoestrógenos
B Terapia de reemplazo hormonal combinada continua
C Terapia de reemplazo hormonal combinada cíclica
D Estrógenos solos continuos
E Progestágenos solos continuos

Respuesta B. Síntomas vasomotores en una mujer con reglas irregulares (útero intacto): terapia de reemplazo hormonal combinada continua, con estrógeno más progestágeno.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 139

Estás evaluando los criterios para elegir el esquema de terapia de reemplazo hormonal. **¿Qué antecedente es indicación del uso de estrógenos orales solos, en la terapia de reemplazo hormonal?**

A Antecedente de cáncer de mama
B Antecedente de dislipidemia
C Antecedente de histerectomía total
D Osteoporosis
E Edad mayor a 70 años

Respuesta C. El progestágeno se agrega únicamente para proteger el endometrio. Si la paciente fue histerectomizada, ya no tiene endometrio que proteger, y se indica estrógeno solo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 87

Mujer de 35 años, con antecedente de histerectomía radical por cáncer de cuello uterino hace 2 años, consulta por bochornos frecuentes, sequedad genital, dispareunia e insomnio. IMC de 28. Colesterol total 221 mg/dL, colesterol HDL 32 mg/dL, triglicéridos 456 mg/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Estrógeno más progestágeno oral
B Estrógeno solo vía oral
C Estrógeno en parches
D Venlafaxina oral
E Progestágenos tópicos

Respuesta C. Histerectomía radical (sin útero, sin ovarios): estrógeno solo, sin progestágeno. Por la hipertrigliceridemia marcada, se prefiere la vía transdérmica, que evita el paso hepático.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 43

Mujer de 56 años postmenopáusica con sequedad vaginal severa, dispareunia y urgencia urinaria. Sin tratamiento actual. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

A Estrógenos tópicos vaginales
B Estrógenos orales sistémicos
C Lubricantes vaginales sin hormonas
D Ospemifeno oral
E Testosterona tópica

Respuesta A. Síndrome genitourinario de la menopausia (sequedad vaginal + dispareunia + síntomas urinarios): primera línea = estrógenos tópicos vaginales (crema, óvulos o anillo). Acción local, mínima absorción sistémica, pueden usarse incluso en pacientes con CA mama en muchos contextos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 47

Mujer en menopausia con sequedad vaginal y dispareunia, atrofia de la mucosa vaginal. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A Lubricante vaginal sin hormonas
B Terapia hormonal sistémica
C Promestrieno tópico vaginal
D Estriol oral
E Tibolona oral

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Promestrieno tópico vaginal (opción C). Promestrieno tópico vaginal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 178

Una mujer de 49 años obesa consulta por síntomas vasomotores consistentes en calor y enrojecimiento de pecho y cara, que ocurren con frecuencia, especialmente en la noche. Refiere que sus menstruaciones son cada vez más infrecuentes, cada 2 a 3 meses. ¿Qué tratamiento es el más adecuado para el manejo de sus síntomas?

A Estrógeno más progesterona vía oral
B Estrógeno más progesterona transdérmicos
C Paroxe2na
D An2concep2vos orales combinados
E Estrógeno tópico

Respuesta B. Los síntomas vasomotores son indicación de terapia de reemplazo hormonal (TRH). Por tener útero se indica una asociación de estrógeno y progestina (en histerectomizadas se usa estrógeno solo). La vía de administración suele ser oral, aunque algunos prefieren la vía transdérmica se recomienda en pacientes obesas y con hipertrigliceridemia. Aunque no existe buena evidencia que respalde estas recomendaciones, la dislipidemia suele ser aceptada por la mayoría de las fuentes como indicación de la...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 42

Mujer de 52 años con menopausia hace 2 años y sequedad vaginal severa. Inicia estrógenos tópicos vaginales. ¿Con qué frecuencia se deben aplicar en la fase de mantenimiento?

A Una vez al día
B Dos veces al día
C Dos o tres veces por semana
D Una vez por semana
E Solo durante el período sintomático

Respuesta C. Estrógenos tópicos vaginales: fase inicial diaria por 2 semanas, luego mantenimiento 2-3 veces por semana. Dos veces al día en mantenimiento es dosis excesiva innecesaria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 88

Una mujer de 52 años presenta reglas irregulares, desde hace 6 meses, asociada a bochornos frecuentes, con calor y enrojecimiento de la cara, que le molestan para dormir. ¿Cuál es la indicación más adecuada?

A Fitoestrógenos
B Terapia de reemplazo hormonal combinada continua
C Terapia de reemplazo hormonal combinada cíclica
D Estrógenos solos continuos
E Progestágenos solos continuos

Respuesta B. La TRH comúnmente indicada es la combinada (estrógeno más progestágeno) continua. Si hubiese sido histerectomizada, se indican estrógenos solos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 47

Una paciente de 68 años, consulta por disuria y dispareunia de 5 meses de evolución, que ha ido en aumento. Cuenta con múltiples exámenes de orina y urocultivos, que han resultado negativos. En su examen físico, se constata mucosa vaginal pálida y seca, flujo patológico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Promestireno tópico vaginal
B 17 beta estradiol por vía oral
C Tibolona oral
D Acetato de medroxiprogesterona por vía oral
E Estradiol más dienogest por vía oral

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: 17 beta estradiol por vía oral (opción B).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 61

Mujer de no se q edad 40-50? Menopáusica con clínica de 5 años de evolución con dispareunia y sequedad vaginal severa, sin ningún otro síntoma. con antecedente de ca de mama en tto con tamoxifeno. preguntan conducta inicial

A Lubricante e hidratante vaginal

B Estrógenos vaginales

C Suspender tamoxifeno

D Observación clínica

E Derivar a urgencia

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Lubricante e hidratante vaginal (opción A).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 4

Una mujer de 54 años, menopáusica hace 2 años, con antecedente de enfermedad coronaria, consulta por sudoración y sensación calor en el pecho y rostro, que ocurre en episodios frecuentes y molestos, mayores en la noche. ¿Cuál es la terapia de elección?

A Estradiol tópico intravaginal

B Escitalopram oral

C Tibolona oral

D Terapia hormonal combinada de 17 beta estradiol más drospirenona por vía oral

E Estradiol y progesterona combinados por vía transdérmica

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Terapia hormonal combinada de 17 beta estradiol más drospirenona por vía oral).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 9

Postmenopáusica con antecedente de IAM y bochornos: a. iniciar Escitalopram

B Resto opciones tenian estradiol

B Ninguna de las anteriores es correcta

C Todas las anteriores son correctas

D No se dispone de información suficiente

E Otra alternativa no descrita

Respuesta A. La alternativa correcta es la A ().

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 75

Una paciente de 51 años, obesa, con antecedente de menopausia a los 48 años, consulta por síntomas vasomotores intensos caracterizados por enrojecimiento y calor de la cara y pecho, mayores en la noche y que son muy molestos. Hace un año se realizó una histerectomía total, debido a diagnóstico de hiperplasia endometrial atípica. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de sus síntomas?

A Estradiol más dienogest por vía oral

B Estriol por vía vaginal

C Estradiol gel, por vía transdérmica

D Anticonceptivos orales combinados

E Venlafaxina vía oral

Respuesta C. Terapia de Reemplazo Hormonal: Los síntomas vasomotores de la menopausia se tratan con terapia de reemplazo hormonal (TRH), a menos que esté contraindicada. Un antecedente de hiperplasia endometrial atípica no contraindica la TRH si ya fue tratada, pero sí lo haría si estuviera activa. La histerectomía implica que la TRH se realice solo con estrógeno, a diferencia de las pacientes con útero que reciben estrógeno y progestágeno. La vía de administración suele ser oral, pero se prefiere la vía...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 19

Mujer con síntomas menopáusicos, con FRCV, histerectomizada, cuál es la mejor opción de manejo: a. Estradiol tópico

B Estradiol

B Amoxicilina

C Ibuprofeno

D Paracetamol

E Omeprazol

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Estradiol (opción B).

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 46

Mujer en menopausia con bochornos y sudoración, antecedente de IAM a los 49 años. ¿Cuál es la terapia más adecuada?

A Terapia hormonal con estrógenos solos
B Terapia hormonal combinada (estrógeno + progestina)
C Tibolona oral
D Clonidina transdérmica
E Escitalopram 10 mg/día

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Escitalopram 10 mg/día). Escitalopram 10 mg/día.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 148

Una paciente de 42 años se realiza un histerectomía radical, por un cáncer de cuello uterino. Evoluciona con bochornos, cefalea y dispareunia profunda, por resequedad vaginal. Al examen físico tiene sobrepeso y presi´pon arterial normal. Además trae exámenes en los que destaca Colesterol total: 204 mg/dl, Colesterol HDL: 54 mg/dl, Triglicéridos: 405 mg/dl. ¿Qué tratamiento es el más adecuado?

A Estrógenos más progestágenos orales
B Estrógenos orales
C Estrógenos en parches
D Progestágenos endovaginales
E Sertralina

Respuesta C. Por estar histerectomizada, debe recibir estrógeno solo y por ser dislipidémica, debe ser por vía transdérmica. Recordar que lo habitual es dar estrógenos más progestágenos, para evitar el riesgo de cáncer de endometrio, pero con la histerectomía, ya no existe el riesgo de dicho cáncer y bastan los estrógenos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 159

Una paciente de 48 años, consulta por episodios de calor y enrojecimiento de la cara y la zona superior del tórax, que duran algunos minutos y ceden espontáneamente, no ha presentado menstruación en los últimos doce meses. Su examen físico es normal. Refiere antecedente de hermana con cáncer de mama. ¿Cuál de los siguientes fármacos indicaría como terapia de reemplazo hormonal en esta paciente?

A Tibolona
B Estrógenos y progestágenos orales
C Estrógenos transdérmicos
D Tamoxifeno
E Venlafaxina

Respuesta A. Por el antecedente familiar de cáncer evitar los estrógenos, pero es fuertemente discutible, ya que las recomendaciones solo plantean como contraindicación al antecedente personal de cáncer de mama y no al antecedente familiar, sin embargo este es uno de los casos en que se da la tibolona, sabiendo que no hay mucha evidencia que lo respalde. La venlafaxina igual se usa, aunque no sirve mucho. Tibolona es la respuesta más correcta.

▶ VER CLASE 3.01.1.028 **Tumores ováricos** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.15 · Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

QUÉ HAY QUE SABER

- Masa anexial: la mayoría son funcionales en edad fértil (quistes foliculares, cuerpo lúteo); en postmenopausia aumenta la probabilidad de malignidad.
- Cáncer de ovario: diagnóstico tardío (>70% en estadio III–IV) con síntomas vagos: distensión, saciedad precoz, dolor sordo, aumento del abdomen; el más frecuente es el seroso de alto grado.
- Ecografía (IOTA): quiste simple unilocular anecoico sin flujo = benigno (control en 6–12 semanas); papilas >3 mm, componente sólido, flujo central o ascitis = sospecha de malignidad.
- Marcadores: CA-125 útil en la postmenopáusica (en la joven sube con endometriosis, miomas, PIP); en la joven con masa sólida pedir AFP, beta-hCG y LDH (tumores germinales).
- Factores de riesgo: BRCA1/2, Lynch, nuliparidad, endometriosis; protectores: ACO, multiparidad, salpingectomía. Masa sospechosa nunca se punciona (siembra peritoneal).
- Manejo inicial: derivar a ginecología (oncológica si hay criterios de malignidad) para cirugía etapificadora y citorreducción. Seguimiento: derivar.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 87

Una paciente de 70 años consulta por dolor abdominal de intensidad progresiva, que inició hace 4 meses. Ha bajado 5 kilogramos de peso. Al examen físico se observa abdomen distendido y destaca una masa anexial de 7 cm, de consistencia aumentada. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Quiste funcional
B Mioma uterino
C Cáncer de ovario
D Cáncer de colon
E Endometriosis

Respuesta C. Mujer postmenopáusica con dolor abdominal progresivo, baja de peso y una masa anexial firme y de consistencia aumentada: es el cuadro clásico del cáncer de ovario, que se presenta tarde y con síntomas inespecíficos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 150

Una paciente de 55 años se realiza una ecografía transvaginal, como parte de un chequeo ginecológico, que visualiza una lesión anexial derecha, quística, de 4,5 cm de diámetro, con una pared fina y sin tabiques ni excescencias. Su última regla fue hace 5 años. ¿Cuál es la

A Realizar laparoscopía
B Iniciar análogos de la GnRH
C Realizar bipsia de la lesión por punción, guiada por ecografía
D Iniciar anticonceptivos orales
E Realizar seguimiento ecográfico en 3 meses

Respuesta E. , ¿A? Es una pregunta muy difícil y en mi opinión es de manejo de especialista y tiene más de una opción de tratamiento. Tiene un quiste simple, en una mujer postmenopáusica. Se puede observar y controlar en 3 meses, dado que probablemente es benigno y actualmente muchos recomiendan observar los quistes simples de menos de 10 cm y solo operarlos si persisten sobre 5 cm a los 3 meses, por el riesgo de rotura y torsión. Sin embargo, algunos opinan que por tener más de 3 cm y ser postmenopáusica,...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 158

Una paciente de 60 años consulta por dolor abdominal de 6 meses de evolución. Al examen físico se palpa una masa anexial derecha, de 8 cm de diámetro, con ascitis significativa. La ecografía transvaginal muestra una masa anexial, multiloculada, con increscencias y excrescencias. Su Ca- 125 resulta 700 UI/L. Se realiza un TAC que muestra engrosamiento peritoneal, probablemente de origen tumoral y se observa un tumor adosado a la pared gástrica y hepática. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Derivar a cuidados paliativos
B Terapia de reemplazo hormonal
C Cirugía más quimioterapia
D Quimioterapia paliativa
E Tamoxifeno

Respuesta D. El cáncer de ovario avanzado, fuera de alcance curativo, se trata con QT paliativa. Pregunta para especialista. No debería hacerse en el Eunacom.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 173

Una paciente de 65 años, nulípara, asintomática, se realiza una ecografía tranvaginal, que muestra un tumor anexial izquierdo, de 23 mm, de aspecto quístico, con paredes lisas, sin tabiques ni excrecencias y sin presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar laparoscopía
B Iniciar terapia de reemplazo hormonal
C Solicitar marcadores tumorales
D Realizar punción del quiste
E Realizar control ecográfico en 3 meses

Respuesta E. Pregunta demasiado específica. Es un tumor anexial en una mujer postmenopáusica (históricamente todos se tratan con anexectomía por laparoscopía). Sin embargo los quistes simples menores a 3 cm se siguen con Ecografía por 3 meses. Si persisten se piden marcadores tumorales y se operan solo si están positivos, ya que de lo contrario solo se observan. Hay estudios recientes que muestran que los quistes anexiales simples son frecuentes en las mujeres postmenopáusicas y que solo una mínima parte...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 165

Una paciente de 73 años presenta dolor abdominal moderado, en hipogastrio y fosa ilíaca izquierda, de 3 meses de evolución, sin otros síntomas. Al examen físico, se palpa una masa en la fosa ilíaca izquierda y, al examen ginecológico, se palpa confirma la masa anexial izquierda, de consistencia dura y 8 cm de diámetro. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A Ecografía abdominal
B Ecografía transvaginal
C Resonancia magnética de abdomen y pelvis
D TAC de abdomen y pelvis
E Histerosonografía

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (TAC de abdomen y pelvis).

▶ VER CLASE 3.01.1.029 Patología benigna de mama

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.14 · Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Fibroadenoma: nódulo firme, móvil, indoloro, bien delimitado en mujer de 15–35 años; ecografía BI-RADS 2–3; observar si es pequeño, resecar si crece o genera dudas.
- Condición fibroquística (30–50 años): mastalgia cíclica bilateral y nodularidad difusa premenstrual; manejo con sostén adecuado y analgesia, tranquilizar.
- Papiloma intraductal: telorrea serohemática uniporo espontánea; estudio con ecografía y resección del conducto. Telorrea bilateral multiporo lechosa: pensar en hiperprolactinemia o fármacos.
- Quiste simple: ecografía diagnóstica, punción solo si es sintomático; mastitis no puerperal y absceso subareolar se asocian a tabaco.
- Primer estudio: ecografía mamaria en <35–40 años, mamografía + ecografía en mayores; BI-RADS 4–5 obliga a biopsia con aguja gruesa.
- Seguimiento completo: el médico general controla los BI-RADS 2 y realiza el control a 6 meses en BI-RADS 3; derivar si crece, cambia de características o hay telorrea hemática.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 161

Una paciente de 24 años se autopalpa un nódulo mamario de 2 cm, indoloro, que no está adherido a la piel ni a planos profundos. Se solicita una ecografía mamaria que muestra una lesión bien delimitada, de 25 mm de diámetro, homogénea, con una fina pared que la rodea. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Quiste mamario
B Fibroadenoma
C Cáncer de mama
D Papiloma mamario
E Tumor filoides

Respuesta B. Mujer joven con nódulo firme, móvil, bien delimitado y homogéneo en la ecografía: es el cuadro clásico del fibroadenoma, el tumor sólido benigno más frecuente entre los 15 y los 35 años.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 169

Una paciente de 43 años, sin antecedentes, consulta por aparición de nódulo mamario, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se palpa nódulo pequeño, no adherido, de consistencia gomosa, sin presencia de adenopatías axilares. Se realiza mamografía inicialmente que es informada como BIRADS 0, por lo que se solicita ecografía mamaria que muestra un nódulo sólido de bordes regulares, con paredes lisas de dos milímetros. La conducta más adecuada en este caso es:

A Control con mamografía anual
B Realizar biopsia estereotáxica
C Realizar tumorectomía con biopsia rápida
D Indicar estrógenos orales y controlar al año con nueva ecografía
E Control con ecografía en seis meses

Respuesta E. Es un fibroadenoma. Se observa, pero se recomienda pedir una Eco en 6 meses porque hay un Cáncer de mama raro, que puede verse igual. Igual es una pregunta muy difícil. También sería correcto la mamografía en un año. Sí estoy seguro que los fibroadenomas se deben controlar al menor por un año con Eco, para asegurarse que no crezcan, como el cáncer raro mencionado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 12

Una mujer de 23 años consulta porque se palpó un nódulo mamario en la mama derecha. Al examen físico tiene un nódulo de 5 cm, que se palpa liso y móvil. Se solicita ecografía mamaria, que muestra un nódulo de aspecto sólido, bien delimitado y encapsulado, de aspecto homogéneo, clasificación US-BIRADS2. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar biopsia estereotáxica
B Control con mamografía en un año
C Solicitar resonancia magnética nuclear de mamas
D Controlar con nueva ecografía mamaria en 6 meses
E Realizar remoción quirúrgica

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Control con mamografía en un año (opción B). El tratamiento de la mastopatía fibroquística es educación de que no es cáncer ni se transforma en cáncer, se resuelve con la menopausia, y AINEs como ácido mefenámico para el dolor.

▶ VER CLASE 3.01.1.030 Cáncer de mama

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.14 · Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Primera causa de muerte por cáncer en la mujer chilena; factores: edad, BRCA1/2, familiar de 1.er grado (sobre todo <40 años), radioterapia torácica joven, hiperplasia atípica, menarquia precoz/menopausia tardía, nuliparidad, obesidad, TRH prolongada.
- Sospecha: nódulo duro, indoloro, adherido, de bordes irregulares; retracción del pezón o la piel, piel de naranja, telorrea hemática uniporo, adenopatía axilar.

- Estudio: mamografía + ecografía; BI-RADS 4–5 → biopsia con aguja gruesa (no PAAF); BI-RADS 0 → completar con ecografía o proyecciones; BI-RADS 3 → control en 6 meses.
- GES: tamizaje con mamografía cada 2 años de 50 a 69 años (alto riesgo genético desde 30–35); confirmación y tratamiento con plazos garantizados ante sospecha.
- Tratamiento según subtipo: luminal A hormonoterapia (tamoxifeno en premenopáusica, inhibidor de aromatasa en postmenopáusica), HER2 + trastuzumab, triple negativo quimioterapia; cirugía conservadora + radioterapia o mastectomía + ganglio centinela.
- Manejo inicial: derivar a especialista (unidad de patología mamaria) ante sospecha clínica o BI-RADS 4–5. Seguimiento: derivar; el médico general controla efectos de tamoxifeno (endometrio, trombosis) e inhibidores (osteoporosis).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 58 años, sin antecedentes, en control de tamizaje GES. Su mamografía bilateral informa un nódulo espiculado de 12 mm en la mama izquierda, con microcalcificaciones agrupadas, clasificado como BI-RADS 5. La paciente está asintomática y solicita saber qué examen sigue. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Control mamográfico en 6 meses

B Punción con aguja fina para estudio citológico

C Biopsia con aguja gruesa guiada por imagen

D Mastectomía total sin confirmación histológica

E Resonancia magnética mamaria de control

Respuesta C. BI-RADS 5 tiene más de 95 % de riesgo de malignidad y exige biopsia con aguja gruesa, que permite diferenciar carcinoma in situ de invasor y obtener el panel de receptores. El control a 6 meses es para BI-RADS 3; la PAAF no aporta lo suficiente; y operar sin biopsia previa es mala práctica.

▶ VER CLASE 3.01.1.031 VIH en ginecobstetricia

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.1 · Infección por VIH: Diagnóstico, Etapificación y Terapia Antirretroviral (TARV GES)

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizaje de VIH en toda embarazada con consentimiento en el 1.er control y repetido en el 3.er trimestre (32–34 semanas); test rápido en el preparto si no hay resultado.
- Test reactivo (ELISA o rápido) es preliminar: segunda muestra al ISP, único facultado para confirmar; en el parto, ante test rápido reactivo se inicia profilaxis sin esperar la confirmación.
- TARV inmediata en toda embarazada con VIH (GES), independiente de CD4; esquema con tenofovir + lamivudina/emtricitabina + dolutegravir; meta carga viral indetectable a las 34–36 semanas.
- Parto: zidovudina EV intraparto si carga viral >1.000 copias o desconocida, y cesárea electiva a las 38 semanas en ese caso; con carga indetectable puede tener parto vaginal.
- Recién nacido: zidovudina oral (± otros ARV si alto riesgo) y suspensión de la lactancia materna (inhibir con cabergolina), con fórmula láctea garantizada.
- Seguimiento: derivar a centro de atención VIH y alto riesgo obstétrico; diagnóstico del niño con PCR seriadas.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 165

Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 32 semanas, sin controles previos, se realiza un Elisa para VIH, que resulta positivo. **¿Cuál es la conducta más importante para evitar la transmisión vertical?**

A Iniciar triterapia antirretroviral ahora

B Realizar cesárea ahora

C Iniciar triterapia antirretroviral si la carga viral es alta

D Administrar terapia antirretroviral durante el trabajo de parto

E Realizar cesárea al llegar a las 38 semanas

Respuesta A. La medida más importante para prevenir la transmisión vertical es la terapia antirretroviral de la madre durante el embarazo, iniciada de inmediato, sin condicionarla a la carga viral. La vía del parto se decide después según la carga viral alcanzada.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Puérpera de 27 años, con infección por VIH en terapia antirretroviral desde el primer trimestre y carga viral indetectable a las 36 semanas. Tuvo un parto vaginal hace 2 horas, con recién nacido sano de término. Pregunta si puede amamantar. **¿Cuál es la recomendación más adecuada según la norma chilena de transmisión vertical?**

A Suspender la lactancia materna, inhibirla con cabergolina y alimentar con fórmula

B Lactancia materna exclusiva, ya que la carga viral es indetectable

C Lactancia mixta durante los primeros 3 meses

D Extraer la leche y administrarla tras congelarla

E Lactancia materna exclusiva si el recién nacido recibe zidovudina

Respuesta A. En Chile la norma de prevención de transmisión vertical del VIH contraindica la lactancia materna aun con carga viral indetectable, porque el riesgo no es cero y existe alternativa segura. Se inhibe la lactancia con cabergolina, se entrega fórmula láctea y el recién nacido recibe profilaxis antirretroviral.

▶ VER CLASE **3.01.1.032** **Incontinencia urinaria** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.6 · Prolapso de Órganos Pélvicos (POP-Q) e Incontinencia Urinaria de Esfuerzo vs Urgencia

QUÉ HAY QUE SABER

- De esfuerzo: escape de poco volumen sincrónico con tos, risa o ejercicio, sin urgencia; por hipermovilidad uretral tras partos vaginales. Prueba de esfuerzo positiva con vejiga llena.
- De urgencia (vejiga hiperactiva): deseo imperioso seguido de escape de mayor volumen, con polaquiuria (≥8/día) y nicturia (≥2); mixta cuando coexisten.
- Estudio inicial: historia, diario miccional, examen pélvico (prolapso, atrofia), urocultivo negativo (descartar ITU), residuo postmiccional; urodinamia antes de cirugía o si hay duda.
- Esfuerzo: ejercicios de Kegel/kinesioterapia de piso pélvico como primera línea; cabestrillo mediouretral (TOT/TVT) si fracasa.
- Urgencia: reeducación vesical (micción por horario), restringir cafeína, anticolinérgicos (oxibutinina, solifenacina) o mirabegrón; la cirugía está contraindicada.
- Rebalse: goteo continuo con residuo alto (obstrucción, neuropatía diabética): estudiar. Seguimiento: derivar a uroginecología si falla el manejo inicial.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 47

Una paciente de 57 años, multípara de 5, presenta incontinencia de esfuerzos moderados. Su examen físico muestra genitales normales, sin prolapso. Tiene sedimento de orina normal y urocultivo negativo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente? **¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?**

A Oxibutinina
B Suspensión uretral
C Terapia de remplazo hormonal
D Kinesioterapia pélvica
E Doxasozina

Respuesta D. Incontinencia de esfuerzo con urocultivo negativo: primero kinesioterapia pélvica. La cirugía de suspensión uretral viene después, si fracasa.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 52 años, con 3 partos vaginales de recién nacidos grandes, consulta por escapes de orina de 2 años. Ocurren al toser fuerte, reírse o hacer ejercicio. Niega deseo urgente de orinar, no tiene polaquiuria y duerme sin levantarse. Al examen, con vejiga llena, se le pide toser y se observa un chorro de escape sincrónico con la tos. El urocultivo es negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar oxibutinina oral
B Indicar ejercicios de Kegel de piso pélvico
C Realizar cistoscopía
D Instalar sonda Foley permanente
E Indicar cabestrillo mediouretral de entrada, sin kinesioterapia previa

Respuesta B. El escape sincrónico con la tos, sin urgencia ni polaquiuria, y con la prueba de esfuerzo positiva, confirma incontinencia urinaria de esfuerzo. El manejo inicial siempre es la kinesioterapia de piso pélvico; el cabestrillo se reserva para cuando esta falla.

Situaciones clínicas de urgencia

21 códigos

▶ VER CLASE **3.01.2.001** **Aborto provocado** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.10 · Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar aborto provocado ante metrorragia del 1.er trimestre con fiebre, flujo fétido, lesiones cervicales o vaginales (pinzas, cuerpos extraños) o relato de uso de misoprostol.
- Aborto séptico: fiebre, taquicardia, útero blando y muy doloroso, flujo fétido por OCI abierto; buscar shock séptico y Clostridium (hemólisis, ictericia, falla renal).
- Manejo inicial: hospitalizar, estabilizar (vías gruesas, cristaloides), hemocultivos y antibióticos EV de amplio espectro (ampicilina + gentamicina + metronidazol, o clindamicina + gentamicina).
- Evacuar el útero (AMEU o legrado suave) con el antibiótico ya circulando; histerectomía solo si no responde o hay necrosis/perforación. Rh(−): anti-D.
- Rige el secreto profesional: la atención no se condiciona a confesión ni denuncia. La Ley 21.030 despenaliza la interrupción solo en 3 causales (riesgo vital, inviabilidad fetal letal, violación hasta 12 semanas o 14 si es menor de 14 años).
- Seguimiento: derivar a ginecología; ofrecer consejería y anticoncepción posaborto.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 24 años, con 10 semanas de amenorrea, consulta en urgencia por metrorragia abundante, fiebre de 38,9 °C y dolor hipogástrico. Reconoce haberse introducido comprimidos de misoprostol comprados por internet hace 3 días. PA 95/60 mmHg, FC 112 lpm. Útero sensible, flujo de mal olor por el orificio cervical abierto. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Dar de alta con misoprostol adicional para completar el aborto

B Denunciar a Fiscalía y diferir el tratamiento hasta su declaración

C Hospitalizar, iniciar antibióticos endovenosos de amplio espectro y evacuar el útero, resguardando el secreto profesional

D Indicar antibióticos orales y control en 7 días

E Realizar histerectomía de urgencia como primera medida

Respuesta C. Es un aborto séptico por un aborto provocado: hospitalizar, estabilizar, antibióticos endovenosos (por ejemplo clindamicina más gentamicina) y evacuación uterina. La atención no puede condicionarse a una confesión ni a una denuncia; rige el secreto profesional. La histerectomía queda para la falla del tratamiento.

▶ VER CLASE 3.01.2.002 Absceso glándula de Bartolino

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.10 · Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso

QUÉ HAY QUE SABER

- Absceso de Bartolino: masa fluctuante, eritematosa, caliente y muy dolorosa en el tercio posterior del labio mayor (a las 4 u 8), que impide sentarse o caminar.
- Diferencial con el quiste de Bartolino: masa indolora sin signos inflamatorios, que se observa si es asintomática.
- Tratamiento de elección: drenaje con marsupialización (sutura de la pared del quiste a la mucosa vestibular, orificio permanente) o catéter de Word por 4 semanas.
- La punción o incisión simple recidiva en >80%: no usarla como tratamiento definitivo. Antibióticos (amoxicilina-clavulánico o cefalosporina + metronidazol) si hay celulitis extensa, inmunosupresión o ITS.
- Tomar cultivo (gonococo, Chlamydia, E. coli) y descartar ITS. En >40 años con masa recurrente o sólida, biopsiar (carcinoma de glándula de Bartolino).
- Seguimiento completo: control a la semana y vigilar recurrencias; baños de asiento y analgesia.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 168

Mujer de 30 años, con actividad sexual, consulta por dolor vulvar y sensación febril. Al examen físico se aprecia un aumento de volumen eritematoso, de 6 centímetros de diámetro, doloroso, en relación a la zona posterior del labio mayor derecho. **¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?**

A Cistectomía de Bartolino

B Drenaje por punción

C Drenaje quirúrgico simple

D Iniciar antibióticos orales y esperar el drenaje espontáneo

E Bartholinocistostomía

Respuesta E. Absceso de Bartolino de 6 cm: la conducta recomendada es la marsupialización (bartholinocistostomía), que drena la colección y crea un orificio permanente, con menor tasa de recidiva que la punción o el drenaje simple.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 111

Mujer de 35 años, con antecedente de tres abscesos de Bartolino que han requerido drenaje quirúrgico, consulta por dolor vulvar de dos días. Al examen se observa un aumento de volumen de 3 centímetros en el labio menor derecho, a tensión, doloroso, sin signos inflamatorios. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Bartholinocistoneostomía

B Evacuación por punción

C Vaciamiento por incisión

D Antibióticos orales

E Baños de asiento y analgésicos

Respuesta A. Recidiva de absceso de Bartolino tras varios drenajes previos: la conducta es la marsupialización (bartholinocistoneostomía), que crea un trayecto de drenaje definitivo y evita una cuarta recidiva.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 148

Mujer de 20 años tras parto vaginal con episiotomía presenta aumento de volumen doloroso, azulado y fluctuante en el labio mayor derecho de 48 horas de evolución. Sin fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico y manejo más adecuado?

A Hematoma vulvar: compresas frías y analgesia si no aumenta

B Absceso vulvar: drenaje + antibióticos

C Quiste de Bartolino: observación ambulatoria

D Linfocele: punción aspirativa

E Tromboflebitis pélvica: anticoagulación

Respuesta B. Absceso vulvar/hematoma infectado post-parto: aumento de volumen azulado + fluctuante + doloroso a las 48h del parto = hematoma infectado o absceso. Requiere drenaje quirúrgico + antibióticos (amoxicilina-clavulánico). El hematoma no infectado (<24h, sin fiebre) se maneja con compresas frías.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 141

Una mujer de 41 años consulta por dolor en la zona vulvar derecha, de dos días de evolución. Al examen físico se observa aumento de volumen eritematoso y muy doloroso a la palpación, de ubicación posterolateral en relación al labio mayor derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Forunculosis vulvar
B Celuli2s vulvar
C Absceso de Bartolino
D Absceso perianal
E Quiste epidermoide vulvar infectado

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Absceso de Bartolino). Es un absceso de Bartholino clásico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 119

Una paciente de 32 años presenta aumento de volumen doloroso en la zona vulvar derecha. Al examen físico se observa aumento de volumen de 3 cm de diámetro, eritematoso y doloroso a la palpación, en relación con el tercio posterior del labio mayor derecho. Refiere haber tenido un episodio previo que requirió drenaje quirúrgico. Además del tratamiento quirúrgico para la lesión actual, ¿qué antibiótico debe administrarse?

A Metronidazol oral
B Ciprofloxacino oral
C Amoxicilina + ácido clavulánico oral
D Azitromicina oral
E Trimetoprim-sulfametoxazol

Respuesta C. Aunque no queda clara la utilidad de los antibióticos en el absceso de Bartholino, los esquemas más utilizados son 1. amoxicilina + ácido calvulánico o 2. Cefadroxilo + metronidazol. Suelen indicarse en los casos con infección severa y en las recurrencias. El tratamiento quirúrgico está indicado en los abscesos menores de 3 cm, con incisión simple. En cambio, en las recurrencias o lesiones de más de 3 cm, se tratan con el catéter de Word (si está disponible es de elección) o marsupialización...

▶ VER CLASE 3.01.2.003 Crisis hipertensiva del embarazo

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.6 · Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio

QUÉ HAY QUE SABER

- Crisis hipertensiva del embarazo: PA ≥160/110 mmHg confirmada en 15 minutos; es criterio de severidad y emergencia por riesgo de ACV materno.
- Evaluar síntomas de severidad: cefalea, escotomas, epigastralgia, convulsiones; exámenes: hemograma, plaquetas, transaminasas, LDH, creatinina, proteinuria; bienestar fetal.
- Tratamiento: labetalol EV en bolos (20 mg, luego 40–80 mg cada 10–20 min, máx. 220–300 mg) o nifedipino oral 10 mg; hidralazina EV 5 mg si hay asma o bradicardia.
- Meta: 140–150/90–100 mmHg; no bajar bruscamente (hipoperfusión placentaria). IECA/ARA-II contraindicados.
- Sulfato de magnesio para prevenir eclampsia (carga 4–5 g EV en 20 min, mantención 1–2 g/h); corticoides si <34 semanas.
- Seguimiento: derivar a alto riesgo obstétrico/hospitalizar para interrupción una vez estabilizada la madre.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 45

Paciente de 32 años, primigesta, cursando un embarazo de 33 semanas, presenta presión arterial de 162/113 mmHg en el control. Se encuentra asintomática y los latidos cardiofetales se auscultan normales. **¿Cuál es el fármaco más adecuado para iniciar el tratamiento?**

A Enalapril
B Sulfato de magnesio
C Metildopa
D Labetalol
E Hidralazina

Respuesta D. PA de 160/110 mmHg o más es una crisis hipertensiva del embarazo: se trata con labetalol endovenoso (hidralazina si está contraindicado). Metildopa es de mantención, enalapril está contraindicado y el magnesio previene convulsiones pero no baja la presión.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 115

Embarazada de 36 semanas con presión arterial 170/110 y cefalea frontal intensa que no cede con analgesia. Sin convulsiones. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

A Hospitalizar, labetalol EV para control de PA, sulfato de magnesio profiláctico e interrupción del embarazo
B Nifedipino oral y control ambulatorio
C Sulfato de magnesio solo
D Inducción con oxitocina inmediata sin otro manejo
E Hidralazina oral y observar

Respuesta A. Preeclampsia severa a ≥34 semanas: hospitalización + control de PA (labetalol o hidralazina EV) + sulfato de magnesio para prevenir eclampsia + interrupción del embarazo una vez estabilizada.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 109

Una paciente de 31 años con 28 semanas de gestación y antecedente de asma severo, presenta un cuadro de cefalea intensa asociada a tinitus. Al examen físico se constata presión arterial de 160/110 mmHg. El registro fetal muestra una frecuencia cardíaca de 135 latidos por minuto. No tiene focalidad neurológica. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada para esta paciente?

A Administrar labetalol endovenoso
B Administrar nifedipino oral
C Administrar sulfato de magnesio endovenoso
D Solicitar TAC de cerebro
E Administrar misoprostol intrarrectal

Respuesta B. Manejo de Crisis Hipertensiva en el Embarazo: La paciente presenta una crisis hipertensiva del embarazo. El tratamiento habitual en estos casos es con labetalol intravenoso. Sin embargo, en esta paciente en particular, el uso de betabloqueadores está absolutamente contraindicado debido a su historial de asma severo. La alternativa de tratamiento en este caso es el nifedipino, que generalmente se administra por vía oral.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 54

Embarazada sobre 20 semanas con cefalea, fotopsias y presión 160/110 mmHg. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

A Nifedipino 10 mg sublingual
B Hidralazina 5 mg EV
C Sulfato de magnesio 4 g EV
D Labetalol 20 mg EV
E Metildopa 500 mg oral

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Labetalol 20 mg EV (opción D). Labetalol 20 mg EV.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 163

Una paciente de 27 años, cursando 36 semanas de embarazo, consulta por malestar general, asociada a cefalea, tinitus y epigastralgia. Su presión arterial es 170/100 mmHg y presenta reflejos osteotendíneos exaltados. Su tacto vaginal no muestra cambios cervicales y su registro cardiaco fetal no tiene alteraciones. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

A Administrar labetalol
B Iniciar alfametildopa
C Administrar sulfato de magnesio 5 gramos endovenoso y luego 2 gramos cada hora
D Solicitar un test de tolerancia a las contracciones
E Realizar cesárea de urgencia

Respuesta C. E? Es una pésima pregunta. Todo el mundo sabe que una preclamsia grave, con probable HELLP y exaltación neurológica, se debe interrumpir o si no, se muere (es lo más importante). Además todos sabemos que primero se administra el sulfato de magnesio, mientras se prepara el pabellón para la cesárea. Como se pregunta la conducta inmediata, probablemente quien redactó esta pregunta quiere que se marque el sulfato de magnesio, pero también se debe hacer la cesárea de manera inmediata, por lo que...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 140

Una paciente de 38 años, cursando embarazo de 36 semanas, consulta por cuadro de una hora de evolución caracterizado por epigastralgia asociada a cefalea, sin otros síntomas. En el examen físico presenta dolor a la palpación de hipocondrio derecho, asociado a exaltación de los reflejos osteotendíneos. Al tacto vaginal se palpa cuello duro y posterior. Se auscultan latidos cardiofetales con variabilidad francamente disminuida. La conducta más adecuada en este caso es:

A Realizar cesárea de urgencia
B Inducir con oxitocina
C Inducir con misoprostol
D Lateralizar a izquierda
E Hospitalizar y esperar a las 37 semanas para realizar interrupción

Respuesta A. Tiene una preclamsia grave, con exaltación neurológica y un HELLP. Hay que interrumpir. Eso sí también hay que dar MgSO4. Si se preguntara lo primero que hay que hacer: sulfato de magnesio. Si se pregunta el tratamiento: interrupción inmediata.

▶ VER CLASE 3.01.2.004 **Eclampsia** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.6 · Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio

QUÉ HAY QUE SABER

- Eclampsia: convulsión tónico-clónica generalizada en embarazada con preeclampsia (o hasta semanas posparto) sin otra causa neurológica; la hemorragia cerebral es su principal causa de muerte.
- Primera medida (tras ABC, decúbito lateral, oxígeno, vía aérea): sulfato de magnesio, aun con antecedente de epilepsia o PA ya controlada; es superior a benzodiacepinas.
- Esquema de Zuspan: carga 4–5 g EV en 20 min y mantención 1–2 g/h hasta 24 h posparto; si convulsiona de nuevo, bolo adicional de 2 g.
- Vigilar cada hora reflejo rotuliano, frecuencia respiratoria (>12) y diuresis (>30 mL/h); toxicidad (arreflexia, depresión respiratoria) → suspender y gluconato de calcio 1 g EV.

- Luego controlar la presión (labetalol o hidralazina EV, meta 140–150/90–100) e interrumpir el embarazo una vez estabilizada, sin esperar madurez fetal.
- Seguimiento: derivar a UCI/alto riesgo obstétrico; neuroimagen si hay déficit focal o convulsión atípica.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 40

Mujer embarazada de 34 semanas es encontrada convulsionando en la calle. Previamente tenía presión arterial de 165/110 mmHg. Al llegar a urgencias persiste con crisis convulsiva. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A Fenitoína IV
B Sulfato de magnesio IV
C Diazepam IV
D Nifedipino sublingual
E Labetalol IV

Respuesta B. Convulsión en una embarazada con presión elevada: eclampsia. El anticonvulsivante de elección es el sulfato de magnesio, no las benzodiacepinas ni la fenitoína. Luego se controla la presión y se evalúa la interrupción del embarazo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 48

Primigesta de 32 semanas con cefalea intensa y presión de 170/110 mmHg, se administra labetalol endovenoso, logrando 140/90 mmHg. Dos horas después presenta una convulsión tónico-clónica de 2 minutos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Administrar lorazepam endovenoso
B Administrar labetalol endovenoso
C Administrar sulfato de magnesio endovenoso
D Administrar tocolíticos endovenosos
E Realizar maduración pulmonar

Respuesta C. Aunque la presión ya esté controlada, la convulsión define eclampsia y exige sulfato de magnesio. Haber tratado bien la presión antes no reemplaza este paso: son dos problemas distintos que se tratan por separado.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Embarazada de 35 semanas, traída por convulsión tónico-clónica de 2 minutos en su casa. Al llegar está en período postictal. PA 174/114 mmHg. Al examen destaca hiperreflexia rotuliana con clonus bilateral. **¿Cuál es la primera medida terapéutica?**

A Administrar labetalol endovenoso
B Administrar sulfato de magnesio endovenoso
C Realizar cesárea de urgencia sin más estudio
D Administrar diazepam endovenoso
E Solicitar tomografía computada de cerebro

Respuesta B. La convulsión con preeclampsia define eclampsia. La primera medida, antes de tratar la presión o decidir la vía de parto, es el sulfato de magnesio: previene la siguiente convulsión y es superior a cualquier benzodiacepina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 144

Una paciente de 25 años, cursando con embarazo de 30 semanas, con antecedente de epilepsia hace 1 año, presenta crisis convulsivas tónico-clónicas, desde hace una hora. Al examen físico se aprecia edema de extremidades inferiores, FC: 87x' y PA: 160/100 mmHg. La ecografía obstétrica muestra feto vivo. ¿Cuál es la primera medida?

A Administrar nifedipino
B Administrar fenobarbital
C Administrar diazepam
D Administrar sulfato de magnesio
E Administrar misoprostol

Respuesta D. Aunque haya teido antecedente de epilepsia, el diagnóstico ahora es una eclam- sia, que en primer lugar recibe MgSO4.

▶ VER CLASE 3.01.2.005 **Embarazo ectópico complicado** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.11 · Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Ectópico roto: dolor abdominal súbito e intenso, signos peritoneales, omalgia (sangre irrita el diafragma), hipotensión y taquicardia en mujer con atraso menstrual o test positivo.
- Ecografía (si no retrasa el manejo): útero vacío, masa anexial y líquido libre abundante en el Douglas; culdocentesis con sangre incoagulable es clásica.
- Manejo inicial: ABC, dos vías venosas gruesas, cristaloides, clasificación y pruebas cruzadas, hemoderivados si es necesario.
- Cirugía de urgencia sin esperar exámenes: laparoscopía si está estable o laparotomía si está inestable, habitualmente salpingectomía.
- Ectópico intersticial: se rompe más tarde con hemorragia masiva. Rh(–): inmunoglobulina anti-D.

- Seguimiento: no requiere controles específicos tras la salpingectomía; consejería sobre riesgo de recurrencia en embarazos futuros (ecografía precoz).

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 62

Mujer joven con dolor súbito en FID, hipotensión y taquicardia súbitas, dolor en ambas fosas ilíacas. **¿Diagnóstico más probable?**

A Apendicitis aguda complicada
B Quiste ovárico torcido
C Embarazo ectópico roto
D Salpingitis aguda con absceso tubo-ovárico
E Rotura folicular hemorrágica

Respuesta C. Mujer joven con dolor en ambas fosas ilíacas e hipotensión y taquicardia súbitas: es la presentación de un embarazo ectópico roto, con hemoperitoneo. El dolor bilateral y el colapso hemodinámico brusco no son típicos de una apendicitis, que suele doler solo a la derecha y no da shock tan súbito.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 62

Mujer joven con dolor súbito en la fosa ilíaca derecha, hipotensión y taquicardia súbitas, con dolor en ambas fosas ilíacas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Apendicitis aguda complicada
B Quiste ovárico torcido
C Embarazo ectópico roto
D Salpingitis aguda con absceso tubo-ovárico
E Rotura folicular hemorrágica

Respuesta C. Dolor súbito con hipotensión y taquicardia súbitas en una mujer joven es el cuadro clásico de hemoperitoneo por rotura tubárica: embarazo ectópico roto.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 176

Una paciente de 24 años consulta por atraso menstrual de 7 semanas. Se realiza HCG, que resulta 5.000 UI/L, por lo que se hace ecografía transvaginal, que muestra au- sencia de gestación intrauterina y abundante líquido libre peritoneal. ¿Cuál es la con- ducta más adecuada?

A Realizar curva de HCG
B Controlar con ecografía transvaginal en 7 días
C Realizar laparoscopía
D Administrar metotrexato
E Mantener el control normal del embarazo

Respuesta C. Es un embarazo ectópico y por tener líquido libre y también más de 3.000 de HCG, es de tratamiento quirúrgico.

▶ VER CLASE 3.01.2.006 Endometritis puerperal

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.19 · Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)

QUÉ HAY QUE SABER

- Causa más frecuente de fiebre puerperal; aparece al 2.º–4.º día con fiebre y calofríos, útero blando, subinvolucionado y doloroso, loquios turbios y de mal olor.
- Factor de riesgo mayor: cesárea, sobre todo de urgencia; también RPM prolongada, corioamnionitis, tactos repetidos, retención de restos y parto prolongado.
- Diferencial de fiebre puerperal: ITU/pielonefritis, infección de herida, mastitis (más tardía), tromboflebitis pélvica séptica (fiebre persistente pese a antibióticos).
- Manejo inicial: hospitalizar siempre, hemocultivos, y clindamicina 600–900 mg c/8 h + gentamicina 5 mg/kg/día EV hasta 48 h afebril; no requiere completar antibióticos orales.
- Ecografía si se sospechan restos (legrado) o absceso; fiebre que no cede en 48–72 h obliga a buscar absceso o tromboflebitis séptica.
- Seguimiento: derivar a ginecobstetricia (manejo hospitalario); se puede mantener la lactancia.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 174

Puérpera hace 7 días, con antecedente de hemorragia puerperal, evoluciona con aumento de la metrorragia, fiebre hasta 38,5 grados y dolor abdominal bajo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Inercia uterina
B Neoplasia trofoblástica gestacional
C Endometritis
D Restos ovulares
E Miometritis

Respuesta C. Fiebre, dolor abdominal bajo y aumento del sangrado en el puerperio es el cuadro clásico de endometritis puerperal, con o sin restos asociados.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Puérpera de tres días, tras una cesárea de urgencia por rotura de membranas prolongada, con fiebre de 38,7 grados, dolor abdominal bajo y útero doloroso, subinvolucionado, con loquios achocolatados y de mal olor. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Manejo ambulatorio con amoxicilina oral

B Hospitalizar e iniciar clindamicina más gentamicina endovenosas

C Indicar ciprofloxacino oral en el domicilio

D Suspender la lactancia mientras se estudia

E Solicitar ecografía mamaria antes de decidir

Respuesta B. Fiebre, dolor uterino, útero subinvolucionado y loquios fétidos tras una cesárea: endometritis puerperal. Se hospitaliza siempre, con clindamicina más gentamicina endovenosas hasta 48 horas afebril.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 151

Una mujer de 25 años, puérpera de 5 días, con parto vaginal, consulta por de aumento de la cantidad de loquios hemáticos y sensación febril. Al examen físico tiene FC: 80x', PA: 110/70 mmHg, examen genital con episiorrafia equimótica y dolor a la palpación uterina. El diagnóstico más probable es:

A Restos placentarios

B Neoplasia trofoblástica gestacional

C Infección de la epifisiorrafia

D Miometritis puerperal

E Endometritis puerperal

Respuesta E. Tiene una endometritis clásica: fiebre, dolor uterino, loquios de mal olor. También puede tener metrorragia. Los restos placentarios solo producen metrorragia tardía, sin dolor ni fiebre (generalmente entre el día 2 y día 4). La NTG suele producir metrorragia tardía, varios días o semanas postparto. La epifisiorrafia equimótica es normal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 171

Una paciente de 26 años, puérpera de 5 días, presenta fiebre, malestar general y loquios de mal olor. Al examen físico tiene dolor a la palpación y se solicita una PCR, que resulta 9,2 mg/L. Se inicia tratamiento antibiótico con penicilina sódica y gentamicina, sin embargo, dos días después, continúa febril, con dolor y PCR 8,8 mg/L. El agente más probable es:

A Proteus mirabilis

B Escherichia coli

C Bacteroides fragilis

D Estreptococo betahemolítico grupo B

E Chlamydia trachomatis

Respuesta C. Por no haber respondido, lo más probable es que sea un anaerobio (por eso se deja penicilina + gentamicina + clindamicina). Las demás opciones estaban cubiertas con el esquema indicado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 152

Una paciente de 32 años, cursando puerperio desde hace 8 días, con parto por cesárea, comienza con loquios abundantes y de mal olor, asociada a fiebre. Su examen físico muestra T°: 38,5°C FC: 85x´. PA: 120/80x', herida operatoria sin signos de infección y útero doloroso a la palpación. La conducta más adecuada es:

A Iniciar ntibióticos orales

B Realizar legrado

C Hospitalizar y manejar con antibióticos endovenosos

D Realizar histerectomía

E Administrar una dosis de antibióticos endovenosos y luego manejo ambulatorio con

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Hospitalizar y manejar con antibióticos endovenosos (opción C). Nuevamente es una endometritis, que se trata con antibióticos endovenosos de amplio espectro.

▶ VER CLASE 3.01.2.007 **Hiperemesis gravídica** DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.21 · Cardiopatía, Embarazo Múltiple e Hiperemesis Gravídica: Riesgo Materno, Corionicidad y Manejo Inicial

QUÉ HAY QUE SABER

- Hiperemesis gravídica: vómitos persistentes del 1.er trimestre con baja de peso >5% del peso previo, deshidratación, cetonuria y alteraciones hidroelectrolíticas.
- Factores: hCG elevada (embarazo múltiple, mola), primigesta, antecedente previo. Descartar mola y gemelar con ecografía, e ITU, gastroenteritis, pancreatitis, hepatitis y hipertiroidismo.
- Exámenes: electrolitos (hipokalemia, alcalosis hipoclorémica), función renal, pruebas hepáticas, TSH/T4L (hipertiroidismo transitorio por hCG), orina completa con cetonuria.
- Tratamiento: hospitalizar si hay deshidratación o intolerancia oral; régimen cero inicial, hidratación EV con suero fisiológico y reposición de potasio; tiamina 100 mg antes de aportar glucosa (prevenir Wernicke).

- Antieméticos: doxilamina-piridoxina, metoclopramida 10 mg EV c/8 h, ondansetrón 4–8 mg (2.ª línea); realimentación oral fraccionada progresiva al ceder los vómitos.
- Seguimiento: no requiere derivación de rutina; manejo en control prenatal habitual una vez resuelto.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 177

Paciente de 18 años, cursando un embarazo de 11 semanas, presenta vómitos frecuentes desde el inicio del embarazo, que han ido en aumento. En las últimas 24 horas ha empeorado al punto de no poder ingerir líquidos adecuadamente, por lo que acude al servicio de urgencia. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Gastroparesia gestacional
B Cólico biliar
C Hepatitis
D Hiperemesis gravídica
E Síndrome de HELLP

Respuesta D. Vómitos persistentes del primer trimestre que impiden la ingesta y llevan a deshidratación definen la hiperemesis gravídica. Se maneja con hospitalización, hidratación endovenosa, reposición de electrolitos, tiamina y antieméticos. El HELLP aparece en la segunda mitad del embarazo con hipertensión, hemólisis y trombocitopenia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 179

Una paciente de 24 años, primigesta de 12 semanas, consulta porque presenta náuseas y vómitos que afectan significativamente su calidad vida. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más adecuado para el manejo inicial de esta paciente?

A Corticoides orales
B Omeprazol oral
C Doxilamina más piridoxina oral
D metoclopramida oral
E Ondasentrón oral

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Doxilamina más piridoxina oral (opción C).

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 56

Embarazada con náuseas y vómitos importantes que impactan su calidad de vida. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A Metoclopramida oral
B Ondansetrón endovenoso
C Dieta fraccionada y observación
D Dimenhidrinato oral
E Doxilamina y piridoxina

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Doxilamina y piridoxina (opción E). Doxilamina y piridoxina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 178

Una paciente de 24 años, cursando un embarazo de 10 semanas, presenta vómitos frecuentes, que iniciaron hace un mes y han ido en aumento. Además ha bajado 3 kilogramos de peso, desde que se embarazó, ya que muchos de los alimentos y olores le producen muchas náuseas y vómitos. Refiere que vomita cerca de 6 veces al día y que esto afecta claramente su calidad de vida. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A Doxilamina
B Clorpromazina
C Omeprazol
D Metoclopramida
E Ondasentrón sublingual

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Doxilamina (opción A). La doxilamina (antihistamínico) son el tratamiento de primera línea en la hiperemesis gravídica.

▶ VER CLASE · 3.01.2.008 · Hemorragia genital aguda (metrorragia disfuncional-cervicorragia por Cáncer C.U.)

DX SOSPECHA · TX INICIAL · SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA

Ginecología 20.3 · Sangrado Uterino Anormal (SUA): Clasificación FIGO PALM-COEIN, Estudio con Biopsia Endometrial y Manejo
Obstetricia 19.18 · Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemorragia uterina aguda severa: estabilizar primero (ABC, dos vías gruesas, cristaloides, hemograma, grupo y Rh, coagulación, beta-hCG); transfundir si hay inestabilidad o anemia severa.
- Metrorragia disfuncional (anovulatoria) en adolescente o perimenopáusica: estrógenos conjugados EV en dosis altas o ACO en esquema escalonado, más ácido tranexámico 1 g c/6–8 h.
- En la adolescente con hipermenorrea importante, descartar coagulopatía (von Willebrand); en ≥45 años, biopsia endometrial antes de terapia hormonal prolongada.

- Si no cede o hay inestabilidad: legrado uterino hemostático (además diagnóstico) o sonda Foley intrauterina como taponamiento.
- Cervicorragia por cáncer cervicouterino: taponaje vaginal compresivo con gasa (± agentes hemostáticos), reposición de volumen y derivación urgente para radioterapia hemostática.
- Seguimiento: una vez controlada, no requiere seguimiento especializado por el sangrado agudo; estudiar la causa de base y derivar según hallazgo.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 122

Mujer de 55 años postmenopáusica con miomas uterinos conocidos. Llega a urgencias por metrorragia severa, con presión arterial de 90/60 mmHg y frecuencia cardíaca de 118 por minuto. **¿Cuál es el manejo inmediato?**

A Estabilización hemodinámica más histerectomía de urgencia
B Ácido tranexámico endovenoso y observar
C Progestágenos endovenosos en dosis alta
D Embolización uterina electiva
E Solo transfusión de glóbulos rojos y alta

Respuesta A. Sangrado uterino masivo con inestabilidad hemodinámica manifiesta: la prioridad es la estabilización con volumen y transfusión, seguida de histerectomía de urgencia como manejo definitivo, sin tiempo para escalar tratamientos médicos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 124

Una paciente, cursando embarazo de término, inicia contracciones uterinas intensas. Al examen obstétrico se palpan tres contracciones cada 10 minutos y dilatación cervical de 5 centímetros. Al romper las membranas, se produce metrorragia moderada, seguida de bradicardia fetal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Rotura uterina
B Desprendimiento de placenta normoinserta
C Placenta previa
D Rotura de vasa previa
E Procidencia de cordón umbilical

Respuesta D. Metrorragia inmediatamente después de romper membranas, seguida de bradicardia fetal, sin dolor ni compromiso materno: rotura de vasa previa. La rotura uterina tiene dolor y cesación de contracciones; el DPPNI tiene hipertonía; la placenta previa no sangra recién al romper membranas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 144

Paciente de 24 años con metrorragia importante en el puerperio inmediato, con flujo abundante de sangre roja. El fondo uterino se palpa por sobre el ombligo. **¿Cuál es la medida inicial más adecuada?**

A Metilergonovina
B Misoprostol
C Masaje uterino
D Carbetocina
E Oxitocina

Respuesta C. Ante una hemorragia postparto por atonía, el primer paso siempre es el masaje uterino bimanual, y en paralelo se inician los uterotónicos, empezando por la oxitocina.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Puérpera de un embarazo gemelar, con trabajo de parto prolongado. Diez minutos después del alumbramiento presenta sangrado masivo, con útero blando a cuatro centímetros sobre el ombligo, sin tono contráctil. Antecedente de preeclampsia con presión habitual de 150/95. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Masaje uterino bimanual, oxitocina, ácido tranexámico, y evitar la ergometrina
B Administrar ergometrina intramuscular de inmediato
C Realizar histerectomía como primera medida
D Revisar el canal del parto en busca de desgarros
E Administrar heparina para descartar coagulopatía

Respuesta A. Sobredistensión por embarazo gemelar más trabajo de parto prolongado: atonía uterina. Se maneja con masaje, oxitocina y ácido tranexámico. La ergometrina está contraindicada por el antecedente hipertensivo; la histerectomía es el último recurso y la heparina empeoraría el sangrado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 99

Una paciente de 47 años, cuya FUR fue hace 55 días, presenta metrorragia de 10 días de evolución, abundante. Se solicita hemograma, que muestra hematocrito: 7,4 g/dl, blancos: 7.000. La conducta más adecuada es:

A Realizar legrado uterino
B Administrar progestágenos orales
C Administrar estrógenos orales
D Realizar histerectomía
E Administrar estrógenos endovenosos

Respuesta A. Tiene una metrorragia grave, anemizante. Por ello, se debe legrar para detener la hemorragia. Lo mismo aplica a las metrorragias graves, asociadas a compromiso hemodinámico. Los estrógenos sí se usan en las metrorragias disfuncionales, pero si es que no tienen ni anemia severa ni compromiso hemodinámico.

▶ VER CLASE 3.01.2.009 Mastitis puerperal

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.19 · Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)

QUÉ HAY QUE SABER

- Mastitis puerperal: placa eritematosa, dolorosa y caliente unilateral, con fiebre alta, calofríos y malestar general, habitualmente en la 2.ª–4.ª semana posparto.
- Diferencial con congestión mamaria: bilateral, primeros días, mamas duras sin fiebre importante; se maneja con vaciamiento, calor y lactancia a libre demanda, sin antibióticos.
- Agente principal: Staphylococcus aureus, por grietas del pezón y vaciamiento incompleto.
- Tratamiento: cloxacilina 500 mg c/6 h VO por 10–14 días (alternativa cefadroxilo; alergia: clindamicina), AINE o paracetamol, frío local tras amamantar.
- Nunca suspender la lactancia: el vaciamiento frecuente (empezando por la mama sana si hay mucho dolor) previene el absceso; corregir acople.
- Si no responde en 48–72 h o aparece masa fluctuante: ecografía para descartar absceso. Seguimiento: no requiere derivación.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 176

Puérpera de 15 días, en lactancia materna, con dolor en la mama derecha de 3 días de evolución, eritema y malestar general. La mama derecha tiene los cuadrantes superiores dolorosos, indurados, con aumento de temperatura local y eritema. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar drenaje mamario quirúrgico
B Suspender la lactancia materna
C Iniciar antibióticos
D Indicar analgésicos
E Aplicar frío y luego calor local, alternadamente

Respuesta C. Mastitis puerperal sin fluctuación: se trata con antibióticos orales con cobertura de estafilococo. No hay indicación de drenaje ni de suspender la lactancia; al contrario, se debe mejorar la técnica de amamantamiento.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 153

Una paciente de 24 años, puérpera de 15 días, presencta dolor en la mama derecha, asociada a eritema, aumento de la temperatura local y fiebre hasta 38,8°C. Al examen físico se aprecia mama derecha eritematosa y congestiva, dolorosa a la palpación, sin zonas fluctuantes. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

A Antiinflamatorios
B Compresión con frío local
C Suspender la lactancia materna
D Drenaje mamario
E Antibióticos orales

Respuesta E. Tiene una mastitis aguda, que se trata con antibióticos, generalmente endovenosos, aunque si está bien se puede tratar con antibióticos orales (generalmente amoxicilina con ácido clavulánico, aunque también se pueden dar otros fármacos que cubran S. aureus).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 170

Una paciente de 30 años, púerpera de 28 días, en lactancia materna, consulta por dolor en la mama derecha, asociado a fiebre hasta 38,5°C. Al examen tiene aumento de volumen y eritema zona superior derecha de la mama, con aumento de volumen palpable, de consistencia aumentada y dolorosa, de 4 cm de diámetro, no fluctuante ni renicente (una palabra inventada por quien hizo esa pregunta), ubicado en el cuadrante superoexterno de dicha mama. El diagnóstico más probable es:

A Congestión mamaria
B Flegmón mamario
C Absceso mamario derecho
D Mastitis derecha
E Cáncer inflamatorio de mama

Respuesta B. Por no ser fluctuante, parece un flegmón mamario. Aunque en estricto rigor igual es una mastitis. Sin embargo, se hacía mucho hincapié en la lesión no fluctuante, por lo que dejaremos flegmón como respuesta correcta. Es una mala pregunta.

▶ VER CLASE 3.01.2.010

Metrorragia: Desprendimiento previo de placenta normoinserta (DPPNI)

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.13 · Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha clínica: metrorragia de sangre oscura (a veces escasa u oculta) con dolor abdominal intenso, útero leñoso (hipertonía) y contracciones seguidas, con sufrimiento fetal precoz.
- Factores de riesgo: síndrome hipertensivo del embarazo (la causa más frecuente), trauma abdominal, cocaína, tabaco, RPM, sobredistensión uterina, DPPNI previo.
- El diagnóstico es clínico: la ecografía solo muestra el hematoma retroplacentario en la mitad de los casos, por lo que una ecografía normal no lo descarta.
- Manejo inicial: ABC, dos vías gruesas, cristaloides, hemograma, pruebas de coagulación y fibrinógeno, sangre disponible; monitoreo fetal.
- Feto vivo: cesárea de urgencia inmediata; feto muerto con madre estable: parto vaginal (amniotomía + oxitocina). Rh(–): anti-D.
- Complicaciones: CID (por tromboplastina), útero de Couvelaire con atonía y hemorragia posparto, shock hipovolémico, insuficiencia renal. Seguimiento: no requiere (resolución hospitalaria).

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 49

Una paciente de 33 años, cursando un embarazo de 36 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas y metrorragia. Al examen se palpa un útero con tono aumentado y tres contracciones uterinas en 10 minutos. La especuloscopía muestra sangre roja oscura en cantidad moderada, sin dilatación cervical. Los latidos cardiofetales se auscultan a 130 por minuto. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar cesárea de urgencia
B Realizar maduración pulmonar y conducta expectante
C Inducir el trabajo de parto con misoprostol
D Solicitar Doppler fetal
E Administrar tocolíticos endovenosos

Respuesta A. Dolor, hipertonía y sangre oscura son un DPPNI. Sin dilatación cervical, la vía más expedita para interrumpir de inmediato es la cesárea de urgencia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 7

Una paciente de 30 años, con embarazo de 35 semanas controlado, consulta al servicio de urgencias por metrorragia escasa asociada a dolor abdominal. Al examen físico destaca aumento marcado del tono uterino de forma permanente y frecuencia cardiaca fetal de 110 por minuto. El diagnóstico más probable es:

A Placenta previa
B Rotura uterina
C Rotura de vasa previa
D Síntomas de parto prematuro
E Desprendimiento de placenta

Respuesta E. Diagnóstico: Desprendimiento de placenta (opción E). Metrorragia más dolor e hipertonía uterina. Además FCF en límite bajo. Metrorragia del tercer trimestre acompañada de dolor abdominal súbito y marcada hipertonía uterina ("útero leñoso o en tabla") con sufrimiento fetal agudo es la tríada clásica de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI), una urgencia obstétrica que exige interrupción inmediata (cesárea).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 166

paciente de 28 años de edad, con 34 semanas de gestación consulta por metrorragia moderada. Al examen físico tiene presión arterial: 130/70 mmHG y FC: 107x', útero doloroso e hipertónico y metrorragia escasa en la especuloscopía. Se realiza ecografía obstétrica que resulta normal, con placenta posterior, sin signos de desprendimiento. El doppler maternofetal resulta normal normal y el cuello tiene 30 mm de longitud. La conducta mas adecuada con la paciente es:

A Administrar nifedipino
B Inducción de parto
C Repetir el doppler fetal en 7 días
D Realizar rotura de membranas
E Realizar cesárea

Respuesta E. Aunque la ecografía no lo vea, el diagnóstico clínico es un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que requiere de interrupción por la vía más expedita: en este caso cesárea, por no estar en trabajo de parto avanzado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 96

DPPNI (útero tónico, sangrado escaso) 32 sem aprox, se evidencia en eco leve desprendimiento de placenta. Cuál es la conducta:

A Cesarea
B Interrumpir 34 sem
C Dar corticoides e interrumpir en 48 hrs, era un DPPNI leve, sin sufrimiento fetal, no creo que sea cesárea de urg más considerando que tiene <34
D Interrupción del embarazo
E Maduración pulmonar y observación

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Cesarea (opción A). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 150

Una paciente de 32 años, con 32 semanas de embarazo, acude al servicio de urgencia por contracciones uterinas dolorosas, asociada a metrorragia. Al examen físico se palpa aumento del tono uterino, se objetiva metrorragia escasa y contracciones uterinas hipertónicas a razón de 3/10 minutos. El cuello uterino no tiene modificaciones y los latidos cardiofetales se auscultan a 120 lpm. La conducta más adecuada es:

A Interrumpir el embarazo de inmediato
B Administrar corticoides intramusculares
C Solicitar perfil biofísico
D Solicitar Doppler materno-fetal
E Administrar tocolíticos

Respuesta A. Tiene un DPPNI sintomático, por lo que se debe interrumpir por la vía más expedita, a pesar de que los LCF estén normales.

▶ VER CLASE 3.01.2.011

Metrorragia: placenta previa

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.13 · Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: metrorragia indolora, roja fresca, súbita, en la segunda mitad del embarazo, con útero blando y feto habitualmente en buen estado; asocia presentaciones anómalas.
- Regla de oro: no hacer tacto vaginal hasta conocer la ubicación de la placenta; diagnóstico con ecografía transvaginal (oclusiva o de inserción baja <2 cm del OCI).
- Factores de riesgo: cesárea anterior (el más importante), multiparidad, legrados previos, edad >35 años, tabaquismo, embarazo múltiple.
- Manejo inicial: hospitalizar si sangra, vías venosas, hemograma, grupo y Rh, reposo, corticoides si <34 semanas, anti-D si Rh(−); sangrado masivo o compromiso materno-fetal → cesárea de urgencia.
- Placenta previa oclusiva: cesárea electiva a las 36–37 semanas; nunca parto vaginal.
- Previa sobre cicatriz de cesárea: alto riesgo de acretismo; derivar a centro de alta complejidad para cesárea-histerectomía programada con placenta in situ. Seguimiento: derivar.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 40

Una paciente multípara, con un parto anterior por cesárea, cursando un nuevo embarazo de 35 semanas, consulta por metrorragia moderada. Al examen físico presenta una contracción uterina cada diez minutos y se realiza ecografía que visualiza una placenta posterior que sobrepasa en dos centímetros el orificio cervical. El ecodoppler materno-fetal es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Administrar tocolíticos
B Inducir el parto con misoprostol
C Administrar corticoides para maduración pulmonar
D Repetir la ecografía a las 37 semanas
E Realizar cesárea

Respuesta E. Placenta que cubre el orificio cervical interno a esta edad gestacional es placenta previa oclusiva. Con 35 semanas cumplidas, el riesgo de prematurez ya es bajo, así que se interrumpe con cesárea sin esperar.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Embarazada de 34 semanas, con una cesárea anterior, consulta por sangrado vaginal rojo fresco y abundante, de inicio súbito hace 1 hora, sin dolor ni contracciones. Al examen: presión arterial 110/70 mmHg, afebril, abdomen blando e indoloro, sin dinámica uterina. El monitor fetal muestra latidos de 142 por minuto, reactivos. El interno se pone guantes para hacer un tacto vaginal. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?**

A Realizar el tacto vaginal para evaluar la dilatación cervical
B Detener el tacto vaginal y solicitar una ecografía transvaginal
C Iniciar tocolíticos endovenosos de inmediato
D Solicitar una tomografía computarizada de abdomen y pelvis
E Indicar deambulación y dar el alta a control ambulatorio

Respuesta B. Sangrado indoloro, rojo fresco, con útero blando y feto reactivo: cuadro típico de placenta previa. Antes de cualquier tacto vaginal hay que conocer la posición de la placenta con ecografía transvaginal, que es segura y no la toca. El tacto puede desgarrarla y provocar una hemorragia exanguinante.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 54

Una mujer de 27 años, cursando un embarazo de 25 semanas, acude a control de su embarazo. Se solicita una ecografía obstétrica, que muestra feto creciendo en percentil 50, con líquido amniótico normal y sin alteraciones morfológicas, observándose que el borde inferior de la placenta se encuentra en contacto con el orificio cervical interno. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Inducir el parto
B Realizar operación cesárea
C Controlar con ecografía en el tercer trimestre
D Administrar tocolíticos desde las 32 semanas
E Solicitar Doppler de arterias uterinas

Respuesta C. Placenta previa: Se diagnostica con la ecografía, cuando la placenta cubre completamente el orificio cervical interno. El diagnóstico generalmente se realiza a las 32 semanas de gestación, ya que antes de esa edad gestacional es frecuente que la placenta se desplace hacia arriba, resolviendo la condición. Sin embargo, si la placenta previa persiste, contraindica absolutamente el parto vaginal y se interrumpe con una cesárea electiva entre las 36 y 37 semanas de gestación. Si se presenta un...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 106

Mujer de 29 años, cursando embarazo de 33 semanas, consulta por presentar metrorragia escasa en una oportunidad no asociado a otros síntomas. Al examen físico no se aprecia sangre proveniente del orificio cervical externo, resto normal. Se realiza registro basal no estresante que resulta reactivo. El diagnóstico más probable en este caso es:

A Rotura de vasa previa
B Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
C Placenta previa
D Rotura uterina
E Sinusorragia

Respuesta C. Para mí es una salida del tapón mucoso (metrorragia escasa y autolimitada). Como no está dentro de las opciones marcaría la Placenta Previa, por estar todo bien, sin compromiso fetal. No habla de relaciones sexuales ni describe lesiones cervicales, como para ser sinusorragia.

▶ VER CLASE 3.01.2.012 Parto prematuro

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.15 · Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección

QUÉ HAY QUE SABER

- Parto prematuro: entre las 22 y 36+6 semanas; amenaza = contracciones dolorosas ≥4 en 20 min (o 8 en 60) con modificaciones cervicales o cervicometría <25 mm.
- Estudio: cervicometría transvaginal (cuello largo = riesgo bajo, observar), especuloscopía para descartar RPM, urocultivo, cultivo de flujo y descartar corioamnionitis o DPPNI.
- Tocolisis solo para ganar 48 h: nifedipino oral (20 mg y luego 10–20 mg c/6–8 h); indometacina solo <32 semanas; atosibán de segunda línea. Contraindicada en corioamnionitis, DPPNI, eclampsia, sufrimiento fetal.
- Corticoides entre 24 y 34 semanas: betametasona 12 mg IM c/24 h x2 (o dexametasona 6 mg c/12 h x4); sulfato de magnesio como neuroprotector si <32 semanas y parto inminente.
- Profilaxis de estreptococo grupo B con penicilina en todo trabajo de parto prematuro con cultivo positivo o desconocido.
- Prevención: progesterona vaginal 200 mg/noche hasta las 36 semanas si cuello <25 mm o parto prematuro previo. Seguimiento: derivar a alto riesgo obstétrico.

PREGUNTAS · 15

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 155

Primigesta de 23 años, cursando un embarazo de 20 semanas, se realiza una ecografía transvaginal que muestra un cuello de 20 mm de longitud, sin otras alteraciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar pesario cervical
B Iniciar progesterona vaginal
C Realizar cerclaje cervical
D Administrar corticoides sistémicos
E Observar evolución, sin intervenir

Respuesta B. Cuello menor a 25 mm en paciente sin antecedente de parto prematuro ni de incompetencia cervical: la conducta es progesterona vaginal. El cerclaje se reserva para cuando además hay antecedente de aborto tardío o parto muy prematuro previo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 72

Una paciente de 27 años, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta en urgencias por contracciones uterinas dolorosas. Al examen físico se constatan contracciones de tres en diez minutos, cuello uterino borrado en un 50 por ciento y con un centímetro de dilatación. La frecuencia cardíaca fetal es de 130 por minuto, con buena variabilidad. **¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo inicial?**

A Ampicilina
B Indometacina
C Nifedipino
D Sulfato de magnesio
E Atosibán

Respuesta C. A partir de las 32 semanas, el tocolítico de primera línea es el nifedipino oral. La indometacina se reserva para menores de 32 semanas. El atosibán es de segunda línea.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 155

Una primigesta de 23 años, cursando un embarazo de 20 semanas, se realiza una ecografía transvaginal que muestra un cuello de 20 milímetros de longitud, sin otras alteraciones. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar pesario cervical
B Iniciar progesterona vaginal
C Realizar cerclaje
D Administrar corticoides sistémicos
E Observar la evolución

Respuesta B. Cuello menor a 25 mm sin antecedentes de partos muy prematuros ni incompetencia cervical: se maneja con progesterona vaginal como prevención primaria. El cerclaje se reserva para quien tiene ese antecedente.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 164

Una paciente de 32 años, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por dolor abdominal. Se constatan contracciones uterinas de tres a cuatro en diez minutos y un tacto vaginal que muestra dilatación de 6 centímetros, con borramiento completo. **¿Cuál de los siguientes fármacos es el más importante para mejorar el pronóstico del recién nacido?**

A Corticoides
B Sulfato de magnesio
C Tocolíticos
D Antibióticos
E Progesterona

Respuesta B. Con 6 cm de dilatación y borramiento completo, el parto ya es inminente: no alcanzan a actuar ni los tocolíticos ni los corticoides. Lo que sí sigue teniendo efecto y protege al recién nacido es el sulfato de magnesio.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Primigesta de 29 semanas consulta por dolor tipo cólico menstrual de 3 horas de evolución. Al examen: signos vitales normales, afebril. El tocodinamómetro muestra 4 contracciones dolorosas en 20 minutos. La cervicometría transvaginal muestra un cuello de 18 milímetros, con dilatación de 1,5 centímetros. No hay pérdida de líquido ni sangrado, y el monitor fetal es reactivo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar reposo en domicilio y control en una semana
B Hospitalizar e iniciar nifedipino, betametasona y sulfato de magnesio
C Realizar cesárea de urgencia por riesgo de parto inminente
D Administrar indometacina rectal por 14 días y dar el alta
E Realizar un cerclaje cervical de urgencia

Respuesta B. Contracciones frecuentes con cuello corto y dilatado a las 29 semanas confirman una amenaza de parto prematuro, sin contraindicaciones para tocolisis. El manejo integral es nifedipino, betametasona, y sulfato de magnesio por ser menor a 32 semanas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 73

Una paciente de 27 años, cursando un embarazo de 32 semanas consulta en el servicio de urgencias, debido a que presenta contracciones uterinas dolorosas en su domicilio. Al examen físico se constatan contracciones uterinas de 3 en 10 minutos y se palpa el cuello uterino borrado en 50%, con dilatación de 1 cm. El registro fetal muestra frecuencia cardíaca fetal basal de 130 latidos por minutos, con buena variabilidad. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo inicial de esta paciente?

A Ampicilina
B Indometacina
C Nifedipino
D Sulfato de magnesio
E Atosibán

Respuesta C. Manejo del Trabajo de Parto Prematuro: En un trabajo de parto prematuro menor a 34 semanas, se usan corticoides y tocolíticos. La indometacina se recomienda en menores de 32 semanas y el nifedipino desde las 32 semanas en adelante. El atosibán es un tocolítico de segunda línea, mientras que la ampicilina sí está indicada cuando avance el trabajo de parto, ya que se usa como profilaxis para el estreptococo del grupo B.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 88

Una mujer de 35 años, multípara de uno, cursando embarazo de 28 semanas, consulta por dolor abdominal, sin otros síntomas. Al examen se aprecia presencia de contracciones uterinas de tres en diez minutos, al tacto vaginal se palpa cuello con un centímetro de dilatación, 50% borrado. Se realiza ecografía transvaginal que muestra cérvix de 18 mm. El fármaco de elección para el manejo de esta paciente es:

A Atosiban
B Nifedipino
C Fenoterol
D Progesterona
E Sulfato de magnesio

Respuesta B. Parto prematuro de menos de 34 semanas, con cuello corto y con algo de modificaciones. Hay que dar corticoides y tocolíticos. Atosiban, fenoterol y nifedipino son opciones. La guía minsal dice nifedipino en primer lugar. Si no frena a las 2 horas, se hace ambocentesis y si no hay bacterias, se dan tocolíticos de segunda línea: fenoterol o atosiván. Clave Eplicación

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 167

Una paciente de 35 años, multípara de 2, tiene un embarazo de 30 semanas. Consulta porque inició contracciones uterinas dolorosas, hace pocas horas. Al examen tiene un cuello 80% borrado, con 2cm de dilatación y 3 contracciones uterinas cada 10 minutos. El registro fetal no muestra alteraciones. ¿Cuál es la medida más importante ante esta paciente?

A Antibióticos
B Tocólisis
C Conducir el trabajo de parto
D Cerclaje
E Interrumpir el embarazo

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Tocólisis). Tiene un parto prematuro menor a 34 semanas, por lo que se debe dar tocolíticos y corticoides. 1.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 11

Una mujer de 30 años, multípara de 1, cursando un embarazo de 29 semanas, con- sulta por dinámica uterina persistente. Al examen físico presenta 3 contracciones uteri- nas en 10 minutos y su tacto vaginal muestra feto en cefálica, con cuello delgado y dila-

A Dar fenoterol endovenoso
B Dar nifedipino oral
C Dar sulfato de magnesio endovenoso
D Realizar cesárea de urgencia
E Administrar corticoides

Respuesta E. Ya que está en fase activa, están contraindicados los tocolíticos. Además la indica- ción relativa (sin evidencia) de la cesárea en el parto prematuro, es cuando tiene menos de 28 semanas o 1Kg. Los corticoides poco servirán, pero siguen siendo indicados en el parto prematuro entre 24 y 34 semanas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 170

Una paciente de 33 años, cursando un embarazo de 31 semanas, presenta contracciones uterinas frecuentes y dolorosas. Además, su tacto vaginal demuestra 2 cm de dilatación y 50% de borramiento. ¿Qué se debe realizar antes, para decidir si se administran o no los tocolíticos?

A Realizar ecodoppler de arterias umbilicales
B Determinar vitalidad y bienestar fetal mediante ecografía
C Realizar ecodoppler de arterias uterinas
D Realizar monitoreo electrónico de la frecuencia cardiaca fetal
E Descartar infección con amniocentesis

Respuesta D. , B? Por regla general, antes de dar los tocolíticos, se debe evaluar si están contraindicados (ej. Óbito fetal, alteración grave del bienestar fetal, dilatación mayor a 3 o 6 cm, etc.). Tanto el registro, como la Ecografía se suelen solicitar. Yo marqué el registro, ya que es lo que suele estar disponible y es más rápido de hacer en ese momento.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 91

Una mujer cursando un embarazo de 27 semanas, presenta dinámica uterina persis- tente y dolorosa, asociada a fiebre hasta 38 grados. Al examen físico tiene temperatura 37,8 grados Celsius, FC: 80x', PA: 120/80 mmHg y 4 contracciones uterinas cada 10 minu- tos, que persisten, a pesar de administrar nifedipino oral. Sus exámenes de sangre de- muestran PCR: 25 ng/ml (VN: menor a 10 ng/ml) y hemograma con 12.000 glóbulos blan- cos por mm3. El monitoreo fetal es tranquilizador. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Interrumpir el embarazo
B Administar fenoterol
C Administrar atosiban
D Realizar amniocentesis
E Iniciar antibióticos

Respuesta D. No alcanzaba a cumplir criterios de coriomanionitis, pero dado que se trataba de un parto prematuro, que no respondía a tocolíticos de primera línea, era necesario rea- lizar la amniocentesis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 164

Una paciente, que cursa un embarazo de 30 semanas de edad gestacional, inicia contracciones uterinas de 3 en 10 minutos. Su tacto vaginal muestra un cuello con 80% de borramiento y 3 cm de dilatación. Se administra nifedipino y la primera dosis de corticoides. Se reevalúa a las 2 horas y persiste con la dinámica uterina de 3 a 4 contracciones en 10 minutos, con 4 cm de dilatación, por lo que se realiza amniocentesis, que da salida a un líquido con escasa bacterias a la tinción de Gram. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Dejar a evolución espontánea
B Administrar la segunda dosis de corticoides
C Determinar madurez fetal en líquido amniótico
D Realizar operación cesárea
E Administrar tocolíticos de segunda línea

Respuesta D. Como tiene infección está contraindicada la tocolisis de segunda línea. No tiene sentido dar la segunda dosis de corticoides. Llama la atención que no aparezcan antibióticos como alternativa, ya que son la medida más importante. Está indicado interrumpir el embarazo, pero por tener 30 semanas, está contraindicado el parto vaginal (contraindicación relativa que tenga menos de 1.500 gramos), por lo que cesárea sería la respuesta más correcta. Igual es una pregunta mala. Los ginecólogos tenían un...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 159

Una paciente de 32 años, con antecedente de un parto prematuro previo a las 30 semanas de gestación, cursa un nuevo embarazo de 13 semanas. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra una longitud cervical de 28mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar cerclaje cervical
B Iniciar tocolíticos a las 28 semanas
C Indicar progesterona endovaginal y realizar cervicometrías seriadas
D Indicar aspirina oral
E Realizar el control habitual del embarazo

Respuesta C. Cuello Uterino Corto: Un cuello uterino corto se define como una longitud cervical menor o igual a 25 mm. La progesterona endovaginal se recomienda en pacientes con cuello uterino corto o con antecedentes de parto prematuro (discutible). Además, el cerclaje se indica si la paciente presenta ambas condiciones.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 165

Una paciente cursa un embarazo de 32 semanas, presenta dinámica uterina 2 a 3 contracciones cada 10 minutos y dilatación cervical de 1 cm. El registro fetal es tranquilizador. Se administran corticoides a la madre, más nifedipino 10 mg vía oral, sin embargo persiste con la dinámica uterina una hora después. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Administrar tocolíticos de segunda línea
B Dejar a evolución espontánea
C Administrar sulfato de magnesio
D Realizar cesárea
E Realizar amniocentesis

Respuesta E. Al fallar los tocolíticos de primera línea, lo primero es descartar una infección con la amniocentesis.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 166

Una mujer de 25 años, primigesta, cursando su embarazo de 22 semanas, se realiza una cervicometría, que muestra un cuello de 25 mm de largo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Mantener conducta expectante
B Indicar progesterona oral
C Indicar progesterona vaginal
D Realizar cerclaje
E Administrar corticoides

Respuesta C. Si bien tiene un cuello corto, el cerclaje solo se indica cuando hay antecedente de abortos tardíos o partos prematuros muy tempranos. De lo contrario, solo se da progesterona vaginal.

▶ VER CLASE **3.01.2.013** **Presentaciones fetales anómalas** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.17 · Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

QUÉ HAY QUE SABER

- La presentación cefálica de vértice es la normal; las anómalas son podálica (3–4% a término), de cara, frente, bregma y la situación transversa.
- Sospecha: maniobras de Leopold (polo duro en fondo uterino en podálica), LCF auscultados sobre el ombligo, tacto vaginal (sacro, cara o miembros); confirmar con ecografía.
- Factores: prematurez, multiparidad, placenta previa, miomas, malformaciones uterinas o fetales, polihidroamnios, embarazo múltiple.
- Podálica a término: ofrecer versión cefálica externa a las 36–37 semanas si no hay contraindicaciones; si persiste, cesárea electiva a las 39 semanas en la mayoría.

- Situación transversa en trabajo de parto: cesárea siempre (riesgo de procidencia de cordón y de rotura uterina); frente: cesárea; cara mentoanterior puede nacer por vía vaginal.
- Manejo inicial del médico general: reconocer y derivar a parto hospitalario; si hay procidencia de cordón, elevar la presentación y cesárea urgente. Seguimiento: no requiere.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 135

Paciente de 35 años, cursando un embarazo de 38 semanas, consulta por contracciones uterinas de 3 a 4 cada 10 minutos. Al tacto vaginal presenta 10 cm de dilatación, membranas rotas y cabeza fetal en espinas 0, en variedad mento-ilíaca derecha posterior. El monitoreo fetal es tranquilizador. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Dejar a evolución espontánea y controlar en una hora

B Hacer fórceps

C Realizar vacuum de la cabeza fetal

D Realizar amnioinfusión con rotación manual

E Hacer cesárea de urgencia

Respuesta E. Presentación de cara con mentón posterior: el cuello fetal ya está en extensión máxima y no puede seguir la curva del canal, por lo que el parto vaginal es imposible. La conducta es cesárea. Solo la cara con mentón anterior (mento-púbica) puede nacer por vía vaginal; el fórceps y el vacuum están contraindicados.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 160

Una paciente primigesta, cursando un embarazo de 37 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas, 3 en 10 minutos. Tiene 8 cm de dilatación, con 100% de borramiento, con feto en posición podálica y registro fetal tranquilizador. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Tocolíticos

B Reversión interna

C Reversión externa

D Fórceps

E Operación cesárea

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Operación cesárea (opción E). Trabajo de parto en podálica contraindica el parto vaginal. Cesárea. La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 23

Mujer en trabajo de parto, feto en cefálica, Bishop 8, dilatación 10 cm, encajado, presentación de cara, Mentón- posterior cual es la conducta

A Cesárea

B Forceps

C Vacum

D Continuar tdp (la presentación de cara no tiene contraindicación de cesárea, la de frente si) eso!!! (Pero ojo la variedad de posición mento púbica = mentón-anterior, es la única NO distócica según Guevara, por lo que la Mentón posterior de este caso debería ser indicación de cesárea)... Había una opción que decía reevaluar en 2 horas

E Realizar prueba de trabajo de parto

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Cesárea (opción A). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

▶ VER CLASE 3.01.2.014 Rotura prematura de membranas

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.14 · Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis

QUÉ HAY QUE SABER

- RPM: pérdida de líquido claro con olor a cloro antes del inicio del trabajo de parto; no hacer tacto vaginal (aumenta infección y acorta la latencia).
- Confirmación: especuloscopía estéril viendo salir líquido por el OCI (Valsalva o Tarnier); si hay duda, PAMG-1 (mayor rendimiento), test de helecho o pH (nitrazina); ecografía con oligoamnios apoya.
- ≥34 semanas: interrumpir (inducción) y profilaxis de estreptococo grupo B si cultivo positivo, desconocido o RPM >12–18 h.
- 24–33+6 semanas sin infección: hospitalizar, ampicilina + eritromicina (48 h EV y luego VO, 7 días en total), betametasona y sulfato de magnesio si <32 semanas; vigilancia de infección.
- Corioamnionitis (fiebre ≥38 °C + 2 menores: taquicardia materna o fetal, útero doloroso, LA fétido, leucocitosis): ampicilina + gentamicina EV e interrupción inmediata; sin tocolisis ni corticoides.
- Seguimiento: derivar a alto riesgo obstétrico para manejo hospitalario.

PREGUNTAS · 12

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 16

Una paciente de 34 años, multípara, embarazada de 36 semanas, presenta pérdida de líquido amniótico hace una hora, confirmándose rotura de membranas con la prueba de microglobulina placentaria. La ecografía obstétrica muestra disminución del líquido amniótico, con presentación cefálica y bienestar fetal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar cesárea
B Administrar corticoides
C Inducir el parto
D Esperar 48 horas para el inicio espontáneo del trabajo de parto
E Administrar antibióticos

Respuesta C. RPM de 34 semanas o más se induce de inmediato si no hay contraindicación de parto vaginal. Los corticoides y los antibióticos de latencia son para las gestaciones menores a 34 semanas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 105

Una paciente de 28 años, cursa un embarazo de 32 semanas por amenorrea, sin controles obstétricos previos, y consulta por pérdida de líquido amniótico. Al examen físico presenta temperatura de 38,5 grados y frecuencia cardíaca de 110 por minuto. La especuloscopía muestra salida de líquido por el orificio cervical. El monitoreo fetal muestra una frecuencia cardíaca fetal de 180 latidos por minuto. La ecografía obstétrica muestra oligoamnios. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Interrumpir el embarazo
B Administrar corticoides y antibióticos, manteniendo una conducta expectante
C Solicitar Doppler materno-fetal
D Realizar amniocentesis
E Realizar amnioinfusión con surfactante intraamniótico

Respuesta A. Fiebre materna con taquicardia materna y fetal, en una RPM de pretérmino, cumple criterios de corioamnionitis clínica. Esto gana por encima de la edad gestacional: se interrumpe el embarazo, sin importar que sea menor a 34 semanas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 96

Una mujer de 34 años, cursando su primer embarazo de 36 semanas, refiere salida de abundante líquido por los genitales. A la especuloscopía no se observa salida de líquido por el orificio cervical externo, y al tacto vaginal se palpa un cuello sin dilatación, posterior y duro, sin borramiento. Una ecografía muestra oligoamnios. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar antibióticos profilácticos y mantener conducta expectante
B Inducir el parto con misoprostol
C Realizar cesárea
D Inducir el parto con oxitocina
E Solicitar un perfil biofísico para tomar la conducta definitiva

Respuesta B. RPM de 36 semanas con cuello posterior, duro y sin dilatación es un Bishop bajo. Con cuello inmaduro, la oxitocina no sirve: se induce con misoprostol para madurar y desencadenar el parto a la vez.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Primigesta de 30 semanas, hospitalizada hace 3 días por rotura prematura de membranas en manejo conservador, presenta fiebre de 38,6 grados, calofríos y taquicardia materna. El útero está hipertónico y muy sensible al tacto. Por la especuloscopía sale líquido amniótico purulento y de mal olor. El monitor fetal muestra taquicardia fetal sostenida, y el hemograma muestra leucocitosis con desviación a la izquierda. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Dar antipiréticos y tocolíticos, y esperar a las 34 semanas
B Iniciar ampicilina más gentamicina endovenosa e interrumpir el embarazo ya
C Dar un segundo ciclo de betametasona y esperar 48 horas
D Realizar una amniocentesis y esperar el resultado del cultivo
E Indicar sulfato de magnesio y mantener la conducta expectante

Respuesta B. Fiebre más taquicardia materna y fetal, útero doloroso, líquido purulento y leucocitosis: cumple criterios de Gibbs para corioamnionitis clínica. Esto contraindica cualquier conducta expectante, tocolisis o corticoides. La conducta es antibióticos endovenosos de amplio espectro e interrupción inmediata.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Paciente de 30 semanas de gestación, primigesta, consulta por pérdida repentina de líquido transparente hace 4 horas, con olor a lavandina, sin dolor ni contracciones. Al examen: afebril, presión y frecuencia cardíaca normales, útero relajado. La especuloscopía estéril confirma la salida de líquido claro al toser. Los latidos fetales son reactivos, y no hay dinámica uterina. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Hospitalizar en ARO, dar betametasona y antibióticos de latencia
B Indicar reposo domiciliario y control en una semana
C Inducir el parto con misoprostol de inmediato
D Realizar cesárea dentro de las próximas horas
E Iniciar tocolisis de mantención por dos semanas

Respuesta A. RPM confirmada a las 30 semanas, sin signos de infección ni trabajo de parto: manejo conservador en ARO, con betametasona para maduración pulmonar y antibióticos de latencia para prolongar el tiempo libre de parto.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 85

Embarazada de 35 semanas con rotura prematura de membranas hace 48 horas. Sin contracciones, sin fiebre, sin signos de infección. Feto en cefálica, sin signos de sufrimiento. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Hospitalizar, maduración pulmonar con corticoides, antibióticos y vigilancia

B Inducción del parto inmediata

C Cesárea de urgencia

D Alta con control ambulatorio

E Amnioinfusión

Respuesta A. RPM a las 35 semanas: manejo conservador con hospitalización, corticoides (betametasona) para maduración pulmonar, antibióticos profilácticos (ampicilina + eritromicina) y monitoreo fetal estrecho.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 165

Una paciente de 35 años, multípara de 1, cursando un nuevo embarazo de 35 semanas, presenta rotura prematura de membranas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar operación cesárea

B Realizar amniocentesis

C Interrumpir el embarazo

D Administrar tocolíticos

E Administrar antibióticos y mantener una conducta expectante

Respuesta C. La RPO mayor a 34 semanas se debe interrumpir, idealmente por vía vagina, a menos que tenga contraindicación del parto vaginal, en que se realiza cesárea.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 75

Embarazada de 35 semanas, multípara de 2, refiere pérdida de líquido claro abundante por genitales, no asociado a otros síntomas. A la especuloscopía no se observa líquido saliendo del orificio cervical externo. Se realiza registro basal no estresante que se encuentra reactivo. El examen de elección para evaluar a esta paciente es:

A Ecografía

B Test de nitrazina

C Test de cristalización

D Detección de alfa 1 microglobulina placentaria

E Medición del pH vaginal

Respuesta D. La PAMG1 es de elección hoy en día, aunque suele no estar disponible y se hace el test de cristalización. Si no apareciera en las alternativas, la respuesta sería el test de cristalización, pero la PAMG1 (altísima sensibilidad y especificidad) es mejor y es la respuesta correcta. Si la pregunta estuviese planteada en términos de costos, eficiencia o algo así, sí sería el test de cristalización.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 121

Una paciente de 28 años, multípara de 2, con un parto nacido por cesárea y el segundo nacido por vía vaginal. Consulta por pérdida de líquido claro por genitales. La especuloscopía no muestra alteraciones, por lo que se realiza un test de nitrazina, con pH: 5,5. La ecografía obstétrica muestra feto en cefálica, con peso acorde para la edad gestacional, con índice de líquido amniótico de 2,2 y 128 latidos cardiofetales por minuto. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Inducir el parto

B Realizar amniocentesis

C Solicitar Doppler fetal

D Realizar operación cesárea

E Mantener una conducta expectante

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Mantener una conducta expectante (opción E).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 128

¿Cuál es la conducta más adecuada para una paciente de 22 años, primigesta, cursando un embarazo de 35 semanas, que sufre una rotura de membranas, sin trabajo de parto?

A Inducir el parto

B Administrar antibióticos terapéuticos

C Administrar corticoides

D Adminitrar tocolíticos

E Administrar sulfato de magnesio

Respuesta A. Toda RPM mayor a 34 semanas se debe interrumpir. Si no tiene contraindicación del parto vaginal, se induce; si tiene contraindicación, se hace una cesárea. En cambio, las menores a 34 semanas se maduran con corticoides, se les da antibióticos y se interrumpen al cumplir 34 semanas, desarrollar una corioamnionitis clínica o comprobarse madurez fetal en la amniocentesis (la que se hace si hay sospecha de infección, sin cumplir criterios de corioamnionitis).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 150

Una paciente de 30 años, embarazada sin controles iniciales, con edad gestacional dudosa, consulta por pérdida de líquido por los genitales. Sus signos vitales son norma- les y al examen obstétrico no presenta dinámica uterina ni modificaciones cervicales en el tacto vaginal. Su altura uterina es de 25 cm y las pruebas de bienestar fetal son normales. Se realiza ecografía obstétrica, que muestra índice de líquido amniótico de 5,2 y biometría para 30 semanas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Inducir el parto con misoprostol
B Realizar cesárea
C Dar antibióticos y corticoides y mantener una conducta expectante
D Determinar madurez fetal en líquido amniótico
E Administrar nifedipino oral

Respuesta C. C, D? Pregunta demasiado específica y difícil y con todo al límite (si quien hizo esta pregunta es la misma persona que preguntó lo de la regurgitación tricuspidea, le comu- nico que no tiene idea de qué debe o no debe saber un médico general). Es una RPO y dado que la edad gestacional es dudosa, se hizo una biometría que tiene un rango de error de 3 semanas: así tiene entre 27 y 33 semanas. Al haber un ILA de 5,2 (aunque no describen el bolsillo, como pra saber si se puede o no hacer una...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 66

Paciente de 35 años, multípara, con un nuevo embarazo de 32 semanas, presenta salida de líquido amniótico por genitales. El test de cristalización confirma rotura prematura ovular. Al examen físico se constata taquicardia materna y fetal, asociada a contracciones uterinas dolorosas y útero doloroso a la palpación. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Inducir el parto
B Realizar cesárea
C Administrar corticoides
D Administrar antibióticos
E Administrar tocolíticos

Respuesta B. Pregunta con información insuficiente. Tiene clínica de corioamnionitis (por lo que es una corioamnionitis), por lo que lo más correcto es interrumpir el embarazo, bajo cobertura antibiótica (clinda-genta). Ninguna de las opciones entregaba el manejo completo. Lo más importante es la interrupción del embarazo, por lo que dejaremos como correcta la B. Es importante aclarar que la corioamnionitis no es indicación per sé de cesárea y puede nacer por parto vaginal, siempre y cuando ya esté en...

▶ VER CLASE 3.01.2.015 Rotura uterina

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.13 · Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: dolor abdominal súbito e intenso durante el trabajo de parto que luego cede junto con las contracciones, metrorragia, ascenso de la presentación y partes fetales palpables bajo la piel.
- Signo más precoz y frecuente: alteración del registro fetal (bradicardia o desaceleraciones prolongadas); luego shock hipovolémico materno.
- Factor de riesgo clave: cicatriz uterina previa (cesárea, miomectomía), sobre todo en prueba de trabajo de parto con oxitocina o inducción con prostaglandinas; también multiparidad y distocias.
- Signo premonitorio (inminencia): anillo de Bandl (retracción patológica) con contracciones intensas en parto obstruido.
- Manejo inicial: ABC, dos vías gruesas, reposición de volumen y hemoderivados, suspender oxitocina; laparotomía de urgencia para extraer al feto y reparar el útero o histerectomía.
- Seguimiento: derivar; en embarazos futuros, cesárea electiva antes del trabajo de parto.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 51

Una paciente de 38 años, cursando embarazo de 38 semanas, inicia trabajo de parto y es ingresada al hospital. Al examen físico presenta cuatro contracciones uterinas cada 10 minutos y se palpa la cabeza fetal encajada, en el tercer plano de Hodge. Durante el parto, evoluciona con metrorragia escasa y dolor abdominal, constatándose elevación de la presentación fetal y cese de las contracciones uterinas. Tiene antecedente de una cesárea previa. El monitoreo fetal muestra descenso de los latidos cardiofetales a 90 por minuto. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Esperar evolución espontánea
B Realizar cesárea de urgencia
C Realizar reanimación fetal
D Administrar tocolíticos endovenosos
E Solicitar pH de cuero cabelludo

Respuesta B. Cese súbito de las contracciones, ascenso de la presentación fetal y bradicardia, con cesárea previa: rotura uterina. La conducta es cesárea de urgencia inmediata, sin perder tiempo en otros exámenes.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 132

Puérpera con una cesárea anterior presenta trabajo de parto espontáneo. A las 2 horas de trabajo de parto activo, refiere dolor uterino súbito diferente a las contracciones, y el MEFI muestra bradicardia fetal sostenida. ¿Cuál es la conducta inmediata?

A Fórceps de urgencia
B Conducción con oxitocina
C Vacuum
D Cesárea de urgencia inmediata
E Espera activa y analgesia

Respuesta D. Rotura uterina (dolor súbito diferente a contracciones + bradicardia fetal + antecedente de cicatriz uterina): emergencia obstétrica máxima. Cesárea de urgencia INMEDIATA. El fórceps/vacuum están absolutamente contraindicados. Sin tratamiento puede ser fatal para madre y feto.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 41

Embarazada con antecedente de cesárea previa, durante el parto presenta cese de contracciones, sangrado y bradicardia fetal. ¿Diagnóstico más probable?

A Desprendimiento prematuro de placenta
B Placenta previa sangrante
C Prolapso de cordón umbilical
D Embolia de líquido amniótico
E Rotura uterina

Respuesta E. Diagnóstico: Rotura uterina (opción E). Rotura uterina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 98

Una paciente de 37 años, multípara de 1, cesarizada anterior, presenta un nuevo embarazo de término. Ingresa a la sala de preparto, por contracciones uterinas doloro- sas. Al examen tiene 3-4 contracciones uterinas cada 10 minutos y tacto vaginal con di-

A Placenta previa
B Procidencia de cordón
C Rotura uterina
D Rotura de vasa previa
E Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta

Respuesta C. Es una rotura uterina clásica, con el antecedente de cesárea y la clínica habitual (dolor, sufrimiento fetal, escasa metrorragia y útero difícil de palpar).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 166

Una paciente de 24 años, multípara de 1, con antecedente de una cesárea previa, por desproporción céfalo pélvica. Cursa con un nuevo embarazo, de término, cuando inicia trabajo de parto. Inicialmente tiene buena dinámica uterina, sin embargo, luego desaparece, agregándose escasa metrorragia. El monitoreo fetal muestra bradicardia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Desprendimiento de placenta
B Rotura uterina
C Rotura de vasa previa
D Placenta previa
E Hipotensión secundaria a la anestesia

Respuesta B. Es una rotura uterina clásica: antecedente de cesárea, contracciones dolorosas que ceden, metrorragia intraparto y sufrimiento fetal.

▶ VER CLASE 3.01.2.016 Dolor pélvico agudo

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG DERIVAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.16 · Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico

QUÉ HAY QUE SABER

- Primer paso en toda mujer en edad fértil con dolor pélvico agudo: beta-hCG y evaluación hemodinámica; positivo con útero vacío obliga a descartar ectópico.
- Torsión anexial: dolor unilateral hiperagudo con vómitos profusos (>80%), quiste de 5–10 cm (teratoma); Doppler: ovario aumentado, edematoso, signo del remolino y flujo ausente o disminuido.
- Quiste hemorrágico roto: dolor poscoital en fase lútea tardía (días 20–26), sin vómitos; ecografía con patrón en red de pesca y líquido libre; manejo médico si está estable.
- Otros diferenciales: PIP/absceso tubo-ovárico (fiebre, flujo, dolor a la movilización cervical), apendicitis, litiasis ureteral, pielonefritis, degeneración de mioma.
- Manejo inicial: analgesia EV, hemograma, PCR, orina, ecografía transvaginal con Doppler; inestable o ectópico roto → cirugía de urgencia.
- Seguimiento: derivar a ginecología de urgencia según diagnóstico (laparoscopía en torsión, hospitalización en PIP grave).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 169

Una paciente de 19 años, con ciclos menstruales regulares, consulta por dolor abdominal intenso, mayor en la fosa ilíaca izquierda. Su fecha de última regla fue hace 20 días. Al examen físico presenta dolor a la palpación con signos peritoneales esbozados. El test de embarazo es negativo, y la ecografía transvaginal muestra una lesión anexial mixta de 8 cm, con líquido libre en moderada cantidad. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Cuerpo lúteo hemorrágico

B Cuerpo lúteo roto

C Apendicitis aguda

D Torsión ovárica

E Absceso tubo-ovárico

Respuesta A. El día 20 del ciclo corresponde a la fase lútea, y la imagen mixta con líquido libre, sin cortejo vegetativo intenso ni signos de compromiso vascular, es el cuadro clásico del cuerpo lúteo hemorrágico, distinto de la torsión y del cuerpo lúteo ya roto con inestabilidad.

▶ VER CLASE 3.01.2.017 Sufrimiento fetal agudo

DX ESPECÍFICO TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.17 · Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipoxia fetal aguda intraparto; se sospecha por alteración del registro cardiotocográfico y se reconoce por categorías: I normal, II indeterminado, III anormal.
- Normal: basal 110–160 lpm, variabilidad 6–25, aceleraciones; desaceleración precoz (espejo de la contracción, compresión cefálica) es benigna.
- Desaceleraciones tardías recurrentes (hipoxia placentaria), variabilidad ausente, bradicardia sostenida <110 o patrón sinusoidal (anemia fetal) = categoría III.
- Reanimación intrauterina: suspender oxitocina, decúbito lateral izquierdo, hidratación EV, oxígeno, corregir hipotensión (anestesia) y tocolisis aguda si hay taquisistolia.
- Categoría III que no mejora: interrupción inmediata por la vía más rápida (cesárea, o fórceps/vacuum si está en expulsivo con condiciones).
- Causas a buscar: DPPNI, rotura uterina, procidencia de cordón, hiperdinamia, hipotensión materna. Seguimiento: no requiere; atención del RN con equipo de reanimación neonatal.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 170

Embarazo de término en trabajo de parto, con seis centímetros de dilatación y variabilidad disminuida de la frecuencia cardíaca fetal. Dos horas después, con ocho centímetros de dilatación, persiste la variabilidad disminuida y aparecen desaceleraciones tardías en relación a cada contracción. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Realizar fórceps

B Realizar operación cesárea

C Administrar misoprostol

D Iniciar oxitocina en goteo

E Mantener conducta expectante y reevaluar en 30 minutos

Respuesta B. Variabilidad disminuida más desaceleraciones tardías recurrentes es categoría tres: sufrimiento fetal que exige la vía más expedita. No se puede hacer fórceps con solo ocho centímetros de dilatación, así que la conducta es cesárea de urgencia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 22

Una mujer de 38 de años, cursando un embarazo de término, inicia trabajo de parto. Actualmente tiene 7 cm de dilatación y se palpa la cabeza fetal ascendida, 2 centímetros por sobre las espinas isquiáticas. Presenta dinámica uterina de 4 a 5 contracciones uterinas cada 10 minutos, recibiendo goteo oxitócico. Luego de 2 horas de observación no se presentan cambios en las condiciones obstétricas y, poco después, aparecen múltiples desaceleraciones tardías en el monitoreo fetal y el líquido amniótico se tiñe de meconio. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Suspender oxitocina, lateralizar y controlar por 30 minutos

B Realizar operación cesárea de inmediato

C Administrar anestesia epidural y conducir el trabajo de parto

D Aumentar la dosis de oxitocina y, una vez que se logre el descenso de la cabeza, realizar fórceps

E Solicitar ecografía Doppler fetal

Respuesta B. Sufrimiento fetal y prueba de parto fracasada: La paciente presenta signos de sufrimiento fetal, incluyendo desaceleraciones tardías en el registro fetal y líquido amniótico meconial. Si bien sería aceptable comenzar con la reanimación intrauterina, en este caso, además, se observa una prueba de parto fracasada, por lo que se debe indica cesárea de inmediato.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 88

Paciente de 30 años, multípara de 1 parto vaginal, presenta parto de término, con 4 cm de dilatación, membranas rotas, se administra anestesia peridural, presentando PA 100/65 mmHg, LCF 90/min y 6 contracciones uterinas cada 10 minutos. La conducta más adecuada es:

A Administrar volumen y monitorizacion fetal

B Realizar cesárea de urgencia

C Iniciar tocolisis de urgencia

D Realizar fórceps

E Iniciar amniotransfusión

Respuesta B. Pareciera un desprendimiento de placenta, pero le falta la metrorragia. De todos modos, está con un sufrimiento fetal agudo (FC: menor a 100) y la bradicardia fetal es indicación de interrumpir por la vía más expedita y en este caso es la cesárea, porque está en fase activa y no se puede hacer un fórceps (a menos que esté en expulsivo: 10 cm, con descenso en tercer plano de Hodge o espinas +2).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 118

Una paciente de 33 años, cursando embarazo de 40 semanas, inicia trabajo de parto. Se realiza control del parto, que constata dilatación cervical completa y cabeza en espinas +2. El monitoreo electrónico fetal muestra lo siguiente: La conducta más adecuada es:

A Realizar cesárea de urgencia

B Realizar fórceps

C Solicitar perfil biofísico

D Lateralizar a la madre y administrarle oxígeno

E Mantener una conducta expectante

Respuesta B. Tiene una bradicardia fetal mantenida (mayor a 10 minutos), por lo que se debe interrumpir inmediatamente por la vía más expedita. En este caso, la vía más expedita es el fórceps, ya que cumple con todos los requisitos: cefálica, dilatación completa, espinas +2 y anestesia (aunque no se menciona, pero tampoco se puede hacer una cesárea sin anestesia).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 71

Una paciente de 28 años, cursando un embarazo de 39 semanas inicia trabajo de parto. Al tacto vaginal, tiene feto en cefálica, con cuello borrado, con 8 cm de dilatación y membranas íntegras. Se realiza un registro fetal intraparto, cuyo trazado se muestra a continuación: INSERTAR FOTO ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Mantener una conducta expectante

B Realizar rotura de membranas

C Realizar cesárea de urgencia

D Iniciar oxitocina endovenosa

E Solicitar perfil biofísico

Respuesta C. Era un registro ominoso, con múltiples desaceleraciones variables complejas. Fal- taba un buen trazado de la dinámica uterina, ya que en ese parecía no haber contracciones.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 148

Una paciente de 27 años, multípara, cursando un embarazo de 38 semanas, en trabajo de parto en fase activa, se produce rotura de membranas, con salida de líquido amniótico claro, luego de lo cual la frecuencia cardíaca fetal disminuye a 90 latidos por minuto. ¿Cuál es la conducta inmediata que debe realizarse en esta paciente?

A Realizar perfil biofísico

B Realizar cesárea

C Cambiar de posición a la madre

D Realizar tacto vaginal

E Realizar Doppler fetal

Respuesta D. Tiene una procidencia de cordón, por lo que se debe interrumpir de inmediato. El TV ayuda a 1. descomprimir el cordón umbilical y 2. determinar las condiciones obstétricas para la vía más expedita de parto (aunque suele ser por cesárea en la procidencia de cordón). La bradicardia también obliga a interrumpir por la vía más expedita (por tanto, hay que hacer también un TV).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 169

Una paciente de 37 años, está en trabajo de parto de término. Está con anestesia raquídea y oxitocina en goteo. Presenta registro electrónico fetal tipo III y se constatan 6 contracciones uterinas cada 10 minutos. La conducta más adecuada es:

A Poner a la madre en decúbito lateral izquierdo

B Suspender la oxitocina

C Realizar rotura artificial de membrana

D Dar oxígeno a la madre

E Administrar tocolíticos

Respuesta B. Tiene un registro ominoso, con taquisistolía, así que lo primero a hacer es suspender la oxitocina. Sin embargo, también hay que lateralizar, dar O2, etc, por lo que es una mala pregunta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 22

Una paciente de 29 años, cursando un embarazo de 36+2 semanas, acude al servicio de urgencia por contracciones uterinas dolorosas y frecuentes. Al examen físico tiene altura uterina: 32 cm, estimación de peso fetal en percentil 25 y se constatan 5 contracciones uterinas cada 10 minutos. El tacto vaginal demuestra dilatación cervical de 4 cm y membranas íntegras. Se auscultan los latidos cardiofetales a 140x' y se realiza registro fetal, que se muestra a continuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar cesárea de urgencia
B Realizar rotura de membranas
C Inducir con misoprostol
D Inducir con goteo oxitócico
E Controlar en dos horas

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar cesárea de urgencia (opción A). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

▶ VER CLASE 3.01.2.018 Pelviperitonitis

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.11 · Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EIP / PIP): Criterios de Hager, Clasificación de Monif y Esquemas Terapéuticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Pelviperitonitis: extensión de un PIP al peritoneo pélvico (Monif II) o rotura de un absceso tubo-ovárico (Monif IV, peritonitis difusa y shock séptico).
- Sospecha: dolor hipogástrico intenso con signos de irritación peritoneal (Blumberg), fiebre alta, dolor a la movilización cervical y anexial, flujo purulento; descartar ectópico con beta-hCG.
- Estudio: hemograma, PCR, hemocultivos, cultivo endocervical, ecografía transvaginal (absceso, líquido libre) o TAC si hay duda con apendicitis.
- Manejo inicial: hospitalizar, hidratación, antibióticos EV (ceftriaxona + doxiciclina + metronidazol, o clindamicina + gentamicina), retirar DIU si lo tiene y está grave.
- Absceso tubo-ovárico >7–8 cm, sin respuesta a 48–72 h o rotura: drenaje percutáneo o cirugía (laparoscopía/laparotomía).
- Seguimiento completo: completar 14 días de antibióticos, control clínico a las 72 h, tratar a la pareja, tamizaje de ITS (VIH, VDRL) y consejería sobre secuelas (infertilidad, ectópico).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 95

Una paciente de 25 años consulta en el servicio de urgencias por dolor abdominal de 3 días de evolución, que ha aumentado de intensidad. Es sexualmente activa y utiliza dispositivo intrauterino tipo T de cobre como método anticonceptivo. Refiere que el dolor es más intenso en el abdomen bajo, mayor al lado derecho. En su examen físico tiene frecuencia cardíaca 108 por minuto y presión arterial 110/70 mmHg, con dolor a la palpación abdominal baja y signo de Blumberg esbozado a derecha. La especuloscopía muestra cuello uterino con secreción purulenta y el tacto vaginal demuestra dolor a la presión cervical y a la palpación de ambos anexos, mayor a derecha. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Embarazo ectópico
B Aborto séptico
C Torsión ovárica
D Pelviperitonitis
E Apendicitis aguda

Respuesta D. Es un proceso inflamatorio pelviano: cervicitis purulenta, dolor a la movilización cervical y anexial bilateral. El signo de Blumberg indica compromiso peritoneal, es decir, pelviperitonitis. Se pide ecografía transvaginal para descartar absceso tubo-ovárico y se tratan con antibióticos de amplio espectro. El DIU no se retira de rutina.

▶ VER CLASE 3.01.2.019 Quiste ovárico torcido

DX SOSPECHA TX INICIAL SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.16 · Urgencias Ginecológicas Quirúrgicas: Torsión Anexial y Rotura de Quiste Ovárico Hemorrágico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: dolor pélvico unilateral súbito, lancinante y con paroxismos, con náuseas y vómitos profusos, en mujer con quiste ovárico conocido (sobre todo teratoma de 5–10 cm).
- Examen: masa anexial dolorosa, defensa localizada; fiebre baja y leucocitosis si hay necrosis. Beta-hCG para descartar ectópico.
- Ecografía Doppler: ovario aumentado y edematoso con folículos periféricos, signo del remolino, flujo ausente o disminuido (un Doppler normal no descarta la torsión).
- Manejo inicial: analgesia, régimen cero y laparoscopía de urgencia sin demora: la isquemia progresa en horas.
- Detorsión conservadora aunque el ovario se vea violáceo, con cistectomía; ooforectomía solo si hay necrosis gangrenosa evidente o sospecha de malignidad.
- Seguimiento completo: control postoperatorio con ecografía a las 6–8 semanas, resultado de biopsia del quiste y vigilancia de recurrencia.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 58

Una paciente de 30 años consulta por dolor en la fosa ilíaca derecha, asociado a vómitos alimentarios, que inició hace 48 horas. Al examen físico: FC 110 por minuto, resistencia muscular involuntaria en la fosa ilíaca derecha. La ecografía transvaginal visualiza un tumor anexial derecho quístico multiloculado, de 10 cm de diámetro, con ausencia de flujo al Doppler color. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A Apendicitis aguda
B Embarazo ectópico
C Proceso inflamatorio pélvico
D Tumor anexial torcido
E Cáncer de ovario

Respuesta D. Aunque la clínica imita una apendicitis, el tumor anexial de 10 cm sin flujo Doppler es una torsión ovárica. El tamaño mayor a 10 cm es el factor de riesgo de mayor peso, y aun con Doppler normal, la sospecha clínica obliga a operar.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 26 años, nulípara, consulta por dolor súbito en fosa ilíaca izquierda de 3 horas, intensidad 9/10, con 3 episodios de vómitos. Test de embarazo negativo. La ecografía Doppler muestra un ovario izquierdo de 8 cm, edematoso, con un quiste de 6 cm compatible con teratoma, y ausencia de flujo venoso. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Analgesia endovenosa y alta con control ambulatorio
B Laparoscopía de urgencia para detorsión ovárica conservadora
C Ooforectomía izquierda abierta, sin intentar destorcer
D Antibióticos endovenosos por sospecha de proceso inflamatorio pélvico
E Punción ecoguiada del quiste para aliviar el dolor

Respuesta B. Dolor unilateral hiperagudo con vómitos profusos, un quiste de riesgo y ausencia de flujo venoso en la ecografía Doppler: es una torsión anexial. La conducta es laparoscopía de urgencia con detorsión ovárica conservadora, preservando el órgano aunque se vea comprometido.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 51

Una paciente de 20 años, consulta por dolor intenso en la fosa iliaca izquierda, de 3 horas de evolución, que se ha asociado a vómitos. Al examen físico está afebril, con signos vitales normales y al examen abdominal presenta intenso dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda, con signo de Blumberg y resistencia muscular. No presenta atraso menstrual. Se solicita ecografía ginecológica, que muestra útero y ovario derecho normales y ovario izquierdo, con aumento de tamaño y presencia de un quiste de 6 x 4 cm, sin flujo al doppler y sin visualización de líquido peritoneal libre. El diagnóstico más probable es:

A Endometrioma
B Cuerpo lúteo hemorrágico
C Quiste ovárico torcido
D Teratoma ovárico
E Embarazo ectópico

Respuesta C. Tanto la clínica (algia pélvica aguda intensa, con náuseas y vómitos), como la presencia de un tumor anexial (principal factor de riesgo), como el doppler alterado son muy sugerentes de torsión ovárica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 63

Mujer joven con dolor pélvico súbito, náuseas, vómitos y masa anexial dura de 7 cm al examen. ¿Diagnóstico más probable?

A Quiste ovárico torsionado
B Embarazo ectópico roto
C Absceso tubo-ovárico
D Mioma pediculado torsionado
E Endometrioma roto

Respuesta A. Diagnóstico: Quiste ovárico torsionado (opción A). Quiste ovárico torsionado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 162

Paciente femenina, en su día 10 de ciclo menstrual, dolor abdominal súbito, con tumor anexial 7 cm, diagnóstico mas probable

A Torsión ovárica
B Endometrioma
C Diverticulitis aguda
D Hemograma y VHS
E Ecografía

Respuesta A. Diagnóstico: Torsión ovárica (opción A).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 113

Una paciente de 24 años, usuaria de anticonceptivos orales, cuya última regla fue hace 8 días, consulta por dolor en la fosa ilíaca derecha, de inicio súbito, intenso, que se ha asociado a náuseas y vómitos alimentarios, en una oportunidad. Al examen físico, tiene FC: 88x', PA: 120/78 mmHg, examen abdominal con dolor a la palpación de la fosa ilíaca derecha y del hipogastrio. Al examen ginecológico, además, se palapa una masa anexial derecha de 6 cm. Se solicita ecografía transvaginal, que visualiza útero de tamaño y paredes normales, endometrio de 6 mm de diámetro, presencia de una lesión anexial derecha quística de 6 cm, sin líquido libre, además, no es posible visualizar el apéndice cecal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Absceso tubo ovárico
B Apendicitis aguda
C Quiste ovárico torcido
D Embarazo ectópico
E Vólvulo de ciego

Respuesta C. Diagnóstico: Quiste ovárico torcido (opción C).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 175

Una niña de 17 años, con antecedente de menarquia a los 15 años y cuyas reglas son irregulares, cada 30 a 40 días. Consulta por dolor pélvico muy intenso, asociado a sudoración y vómitos. Al preguntarle dirigidamente, niega actividad sexual. Al examen físico se observa adolorida, quejumbrosa y se palpa una masa hipogástrica de 7 cm de diámetro, muy dolorosa. El diagnóstico más probable es:

A Cáncer de ovario
B Absceso tuboperitoneal
C Síntomas de aborto
D Torsión anexial
E Pelviperitonitis

Respuesta D. Diagnóstico: Torsión anexial (opción D). Parece una torsión ovárica clásica: dolor intenso, asociado a vómitos, de inicio súbito.

▶ VER CLASE 3.01.2.020 Mastitis abscedada

DX ESPECÍFICO TX COMPLETO SEG COMPLETO

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.19 · Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)

QUÉ HAY QUE SABER

- Absceso mamario: complicación de una mastitis mal tratada o sin tratar (3–10%); masa fluctuante, muy dolorosa, con eritema y fiebre persistente pese a 48–72 h de antibióticos.
- Confirmación: ecografía mamaria (colección hipoecogénica), que además guía el drenaje.
- Tratamiento de elección: punción aspirativa ecoguiada (repetible) en abscesos pequeños; drenaje quirúrgico (incisión periareolar o radial) si es grande, multiloculado o con piel comprometida.
- Antibiótico antiestafilocócico: cloxacilina 500 mg c/6 h VO por 10–14 días; cultivo del pus y cobertura de SAMR (clindamicina o cotrimoxazol) si no responde.
- Lactancia: mantenerla desde la mama sana y vaciar la afectada (extracción); amamantar de ella si la incisión está lejos del pezón.
- Seguimiento completo: control clínico y ecográfico hasta la resolución; absceso recurrente o masa persistente fuera del puerperio obliga a descartar carcinoma.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 64

Una paciente de 32 años, puérpera de parto vaginal eutócico de 8 días de evolución, consulta por dolor mamario derecho, mayor durante la lactancia. Al examen físico tiene T°: 38,5°C, FC: 100x', PA: 120/78 mmHg. Ambas mamas se observan eritematosas, con grietas visibles en el pezón y, en el lado derecho, se palpa aumento de volumen doloroso y fluctuante a la palpación, de 6 cm de diámetro, con aumento de la temperatura local y eritema. El examen ginecológico no tiene alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Antibióticos endovenosos más drenaje quirúrgico o por punción guiado por ecografía
B Drenaje por punción
C Suspender la lactancia materna
D Frío local y paracetamol
E Amoxicilina más ácido clavulánico vía oral

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Suspender la lactancia materna (opción C).

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 51

Puérpera con fiebre, eritema mamario, calor local y aumento de volumen fluctuante. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Antibiótico oral y continuar lactancia

B Antibiótico endovenoso y suspender lactancia

C Antiinflamatorios y masaje local

D Antibiótico y bromocriptina para suspender lactancia

E Drenaje quirúrgico y antibióticos

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Drenaje quirúrgico y antibióticos (opción E). Drenaje quirúrgico y antibióticos. La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 73

Paciente puérpera con mama eritematosa con calor local y aumento de volumen fluctuante de 7 cm, además de iniciar atb, se debe; a. Drenaje de absceso mamario,

B Suspender LM

B Psoriasis

C Dermatitis atópica

D Dermatitis de contacto

E Liquen plano

Respuesta A. La alternativa correcta es la A ().

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Puérpera de 26 años, a las 3 semanas de un parto vaginal, con lactancia materna exclusiva. Consulta por dolor en la mama derecha y fiebre de 38,8 °C. Hace 6 días se diagnosticó mastitis y se indicó cloxacilina oral, que ha cumplido. Al examen hay una zona eritematosa en el cuadrante superoexterno con un área fluctuante de 3 cm, muy dolorosa. La ecografía muestra una colección hipoecogénica de 3 cm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar mamografía y biopsia core antes de tratar

B Cambiar a ciprofloxacino oral y suspender la lactancia

C Indicar cabergolina para inhibir la lactancia y compresas frías

D Punción aspirativa ecoguiada del absceso, mantener antibiótico antiestafilocócico y la lactancia

E Continuar la misma cloxacilina por 14 días más, sin otra intervención

Respuesta D. La masa fluctuante con colección ecográfica tras una mastitis tratada corresponde a un absceso mamario. Debe drenarse (punción ecoguiada en abscesos pequeños; quirúrgico si es grande o multiloculado), manteniendo el antibiótico antiestafilocócico y la lactancia. El antibiótico solo no basta y suspender la lactancia empeora la estasis.

▶ VER CLASE 3.01.2.021 **Trabajo parto distócico** DX SOSPECHA TX INICIAL SEG NO REQUIERE

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.17 · Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

QUÉ HAY QUE SABER

- Distocia: trabajo de parto que no progresa. Fase activa prolongada: dilatación <1 cm/h; detención: sin progreso de dilatación por ≥2–4 h con buena dinámica (o descenso en expulsivo).
- Evaluar las 3 P: potencia (hipodinamia), pasajero (macrosomía, variedades posteriores, deflexión) y pasaje (desproporción céfalo-pélvica: cabeza no desciende, suturas cabalgadas, caput voluminoso).
- Hipodinamia con condiciones: amniotomía y conducción con oxitocina; DCP o detención en fase activa con buena dinámica → cesárea.
- Distocia de hombros (signo de la tortuga, típica en macrosomía y diabetes): pedir ayuda, McRoberts + presión suprapúbica (resuelve >70%), luego maniobras internas (Rubin, Woods, Jacquemier).
- Nunca Kristeller ni tracción forzada de la cabeza (lesión del plexo braquial); Zavanelli o fractura de clavícula son de último recurso.
- Manejo del médico general: reconocer, monitorizar bienestar fetal, iniciar medidas y derivar; vigilar hemorragia posparto por atonía tras parto prolongado. Seguimiento: no requiere.

PREGUNTAS · 6

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 141

Embarazada de 39 semanas en trabajo de parto activo. Lleva 4 horas en fase activa con la dilatación cervical detenida en 5 centímetros, con dinámica uterina regular, de 4 contracciones de 45 segundos cada 10 minutos, y la presentación fetal ya encajada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Fórceps

B Conducción con oxitocina

C Esperar en observación 2 horas más

D Cesárea de urgencia

E Vacuum extractor

Respuesta B. Detención de la fase activa por dinámica insuficiente, sin sufrimiento fetal ni desproporción, no es indicación directa de cesárea. Primero se intenta conducir el trabajo de parto con oxitocina, para mejorar la dinámica uterina.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 168

Paciente en trabajo de parto de término. Durante el expulsivo se produce el desprendimiento de la cabeza fetal, pero no ocurre la rotación ni el descenso de los hombros. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A Traccionar la cabeza fetal

B Realizar compresiones suprapúbicas

C Realizar hiperflexión de las caderas (maniobra de McRoberts)

D Realizar rotación manual de los hombros hacia anterior (maniobra de Rubin)

E Realizar extracción del brazo posterior (maniobra de Jacquemier)

Respuesta C. La maniobra de McRoberts es siempre el manejo inicial en la distocia de hombros: resuelve la mayoría de los casos y tiene muy baja morbilidad. Las maniobras internas y la tracción cefálica quedan para después, o están prohibidas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Primigesta de 39 semanas, con diabetes gestacional, en expulsivo. Tras la salida de la cabeza fetal, esta se retrae con fuerza contra el periné. La tracción axial suave no libera el hombro anterior. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Presionar el fondo uterino con ambas manos (maniobra de Kristeller)

B Maniobra de McRoberts más presión suprapúbica (Mazzanti)

C Traccionar con firmeza la cabeza fetal hacia abajo

D Realizar cesárea con el feto ya desprendido (maniobra de Zavanelli)

E Fracturar de inmediato la clavícula fetal

Respuesta B. Signo de la tortuga con hombro atascado: distocia de hombros. La primera línea, con más del setenta por ciento de éxito, es McRoberts más presión suprapúbica. Kristeller y la tracción cefálica están prohibidas; Zavanelli y la fractura de clavícula son de último recurso.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 105

Una paciente de 30 años, mul` para de uno, con antecedente de parto vaginal de recién nacido de 4.000 gramos, cursa nuevo embarazo de término con estimación de peso fetal de 3.800 gramos. Ingresa en trabajo de parto en fase latente, recibiendo anestesia peridural a los 4 cm de dilatación. Ha permanecido con 6 cm de dilatación en las últimas 3 horas y se palpa cabeza fetal en el segundo plano de Hodge, en variante occípito-ilíaca izquierda posterior. Presenta cuatro contracciones uterinas de 50 segundos de duración cada 10 minutos. ¿Cuál es la causa de la demora en el avance de su trabajo de parto?

A Dinámica uterina insuficiente

B Distocia de posición

C Desproporción céfalo-pélvica

D Macrosomía fetal

E Distocia de presentación

Respuesta B. Tiene buena dinámica (3-5 contracciones cada 10 minutos). Está en presentación cefálica de vértice (punto de referencia es el occipucio), así que no hay distocia de presentación. No Gene criterios de macrosomía fetal (mayor a 4.500 gramos). Tiene posición occipital posterior persistente, lo que es compatible con una distocia de posición. La posición es la rotación del feto en relación a la pelvis (se describe con el punto de referencia, en relación a una parte de la pelvis). La mayoría de los...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 33

Una mujer de 24 años, primípara, en trabajo de parto, con dilatación completa, membranas rotas y buena dinámica. Cuenta con episiotomía mediolateral. Se produce desprendimiento de la cabeza fetal, sin embargo, el resto del cuerpo no progresa, luego de 5 minutos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Ampliar la epifisiotomía

B Realizar tracción continua por 5 minutos

C Realizar flexión de las caderas de la madre y realizar compresión suprapúbica

D Girar el hombro posterior, en el sentido de las agujas del reloj

E Poner a la madre en posición genupectoral y realizar suave tracción de la cabeza fetal

Respuesta C. El manejo de la retención de hombros sigue un orden específico: Primero: realizar hiperflexión de la cadera (maniobra de Mc Roberts). Segundo: realizar compresión suprapúbica (maniobra de Manzzanti / Rubbins). Tercero: intentar rotación del tronco u otra maniobra para sacar el hombro. De no funcionar nada se hacen maniobras más invasivas como sinfisiotomía púbica o fractura de la clavícula fetal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 102

Una mujer de 24 años, primípara, en trabajo de parto avanzado. Se produce desprendimiento de la cabeza fetal, sin embargo, no se produce la rotación de la cabeza, ni el descenso de los hombros. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Pivotear la cabeza

B Realizar compresión de la región suprapúbica (maniobra de Kristeller)

C Rotar el hombro hacia anterior

D Realizar hiperflexión de las caderas (maniobra de McRoberts)

E Realizar fórceps

Respuesta D. El manejo de la retención de hombros es primero la D, luego la B y luego la C, seguido de maniobras más agresivas (fracturar la clavícula del RN, sinfisiotomía púbica).

Conocimientos generales

16 códigos

▶ VER CLASE 3.01.3.001 **Control prenatal**

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.1 · Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre

QUÉ HAY QUE SABER

- Primer control idealmente antes de las 12 semanas (ingreso precoz): anamnesis de riesgo, PA, IMC, examen físico y mamario, y datación por FUM confiable y ecografía precoz.
- Exámenes del 1.er trimestre: grupo, Rh y Coombs indirecto, hemograma, VDRL/RPR, VIH (con consentimiento), glicemia de ayuno, urocultivo, orina completa, PAP si corresponde; hepatitis B y Chagas según norma.
- Segundo y tercer trimestre: PTGO 75 g a las 24–28 semanas; repetir VDRL, VIH y hemograma a las 28–32 semanas; cultivo vaginorrectal de estreptococo grupo B a las 35–37 semanas.
- Suplementación: ácido fólico 0,4–1 mg/día (4–5 mg si alto riesgo de DTN) desde 3 meses antes hasta las 12 semanas; calcio 1.000–1.500 mg/día desde las 12–16; hierro 30–60 mg/día desde las 16–20.
- Ecografías de rutina: 11–14 semanas (datación, translucencia nucal, Doppler uterinas), 20–24 (anatomía y cervicometría) y 30–34 (crecimiento, placenta, líquido).
- Vacunas: influenza en cualquier trimestre, dTpa desde las 28 semanas; derivar a alto riesgo ante HTA, diabetes, RCF, embarazo múltiple u otra patología. Educación en signos de alarma y plan de parto (Chile Crece Contigo).

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 38

Paciente de 25 años, vegana estricta, con antecedente de un parto hace 6 meses de un hijo con mielomeningocele, consulta porque desea planificar un nuevo embarazo. **¿Qué suplemento se le debe indicar de manera prioritaria?**

A Vitamina B12
B Ácido fólico
C Calcio
D Hierro
E Ácidos grasos omega-3

Respuesta B. La dieta vegana estricta se asocia sobre todo a déficit de vitamina B12, pero el antecedente de un hijo con defecto del tubo neural manda por sobre eso: se indica ácido fólico en dosis alta (4 mg/día), idealmente desde 3 meses antes del embarazo y hasta la semana 12.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Primigesta de 9 semanas por FUM confiable, sin antecedentes mórbidos, acude a su primer control prenatal. Pregunta qué debe empezar a tomar y qué exámenes se le van a solicitar. **¿Cuál es la indicación correcta para este control?**

A Ácido fólico 0,4 a 1 mg al día y batería completa de exámenes del primer trimestre
B Ácido fólico 4 a 5 mg al día, por tratarse de su primer embarazo
C Iniciar carbonato de calcio 1.000 mg al día desde este control
D Solicitar la PTGO de 75 gramos en este mismo control
E Iniciar hierro oral profiláctico desde este control

Respuesta A. Sin antecedentes de riesgo, el ácido fólico es en dosis de bajo riesgo (0,4–1 mg/día), y a las 9 semanas corresponde la batería del primer trimestre. El calcio se inicia recién a las 12–16 semanas, la PTGO a las 24–28 semanas, y el hierro desde las 16–20 semanas: ninguno de los tres corresponde todavía.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 42

Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 42 semanas acude a control. No presenta dinámica uterina y la altura uterina es acorde a la edad gestacional. Los latidos cardiofetales son de 125 lpm. Se realiza ecografía obstétrica que estima un peso fetal de 3.600 g, y visualiza un bolsillo mayor de líquido amniótico de 3 cm. El Doppler fetal es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Citar a control en 3 días
B Citar para inducción del parto en 3 días
C Inducir el parto en este momento con misoprostol
D Realizar cesárea
E Solicitar test de tolerancia a las contracciones

Respuesta C. Desde las 42 semanas se considera un embarazo postérmino, con riesgos asociados (sufrimiento fetal el más importante) y se debe interrumpir. Si está todo bien (como en este caso), la vía de elección es vaginal. De hecho, se recomienda interrumpir desde las 41 semanas y se considera aceptable hacerlo desde las 39 semanas, ya que no se ha visto mayor riesgo en hacerlo. En resumen, 42 semanas: "se debe"; 41 semanas: "se recomienda"; 39 semanas "se acepta" interrumpir.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 17

Glucosuria en embarazo de 24 semanas con HGT normal es indicativo de a. Normal

B Hallazgo precoz de preeclampsia

C Hallazgo precoz de daño renal crónico

D Hallazgo de alteración de tubo proximal (no recuerdo muy bien)

D Interrupción del embarazo

E Maduración pulmonar y observación

Respuesta A. La alternativa correcta es la A ().

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 95

¿Como es la suplem nientación con ácido fólico en embarazo según la guía perinatal?: a. 3 meses preconcepcional hasta las 12 semanas de edad gestacional

A Interrupción del embarazo

B Maduración pulmonar y observación

C Cesárea de urgencia

D Inducción del parto

E Control prenatal habitual

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Interrupción del embarazo).

▶ VER CLASE 3.01.3.002

Derechos y aspectos legales de la embarazada y su pareja

DÓNDE SE ENSEÑA

Obstetricia 19.10 · Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030
Salud Pública 21.14 · Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Ley 21.030: despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo solo en 3 causales: riesgo vital materno (sin límite de semanas), inviabilidad fetal letal (dos especialistas concordantes) y violación (hasta 12 semanas; 14 si es menor de 14 años).
- Objeción de conciencia: personal, manifestada previamente por escrito; el objetor debe derivar de inmediato a un médico no objetor y no puede objetar si hay riesgo vital inminente sin otro médico disponible.
- Secreto profesional: la atención de un aborto en curso o complicado nunca se condiciona a denuncia o confesión.
- Protección laboral: fuero maternal desde la concepción hasta 1 año después del posnatal, descanso prenatal de 6 semanas y posnatal de 12 semanas más posnatal parental, derecho a alimentar al hijo (1 hora diaria) hasta los 2 años y sala cuna según tamaño de la empresa.
- Derecho a acompañamiento por una persona de su elección durante el trabajo de parto y parto, a información y a un trato digno; la pareja puede usar parte del posnatal parental y tiene permiso de paternidad.
- Garantías: GES de parto prematuro, VIH, analgesia del parto, entre otros; programa Chile Crece Contigo desde el primer control prenatal.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 118

Paciente de 22 años, con un embarazo de 18 semanas, acude a urgencias solicitando la interrupción voluntaria del embarazo. No presenta ninguna de las tres causales legales vigentes en Chile. **¿Cuál es la conducta médica correcta?**

A Informar que la interrupción no procede legalmente y derivar a consejería

B Realizar la interrupción por solicitud de la paciente

C Derivar de urgencia a matrona

D Hospitalizar para observación

E Referir a comité de ética del hospital

Respuesta A. La ley chilena solo permite la interrupción en las tres causales: riesgo vital, inviabilidad fetal letal y violación. Sin ninguna de ellas presente, no procede, y la conducta es informar, orientar y derivar a apoyo psicosocial.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 118

Paciente de 22 años con embarazo de 18 semanas acude a urgencias solicitando la interrupción voluntaria del embarazo. No presenta ninguna de las tres causales legales vigentes en Chile. **¿Cuál es la conducta médica correcta?**

A Informar que la interrupción no procede legalmente y derivar a consejería

B Realizar la interrupción por solicitud de la paciente

C Derivar de urgencia a matrona

D Hospitalizar para observación

E Referir al comité de ética del hospital

Respuesta A. La Ley 21.030 permite la interrupción solo dentro de las tres causales taxativas. Sin ninguna de ellas presente, la interrupción no procede aunque la paciente la solicite: el médico debe informar, orientar y derivar a apoyo psicosocial, no ejecutar el procedimiento ni delegarlo sin fundamento legal.

▶ VER CLASE 3.01.3.003 Determinación de edad gestacional

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.1 · Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre

QUÉ HAY QUE SABER

- Edad gestacional = semanas desde el 1.er día de la última regla (FUM); fecha probable de parto por regla de Naegele: FUM + 7 días − 3 meses (+1 año).
- La FUM solo es confiable si es segura, con ciclos regulares y sin uso de ACO, lactancia o embarazo reciente en los 3 meses previos.
- Ecografía precoz con longitud céfalo-nalgas (7–14 semanas) es el método más preciso (±3–5 días); si difiere >5–7 días de la FUM, se corrige por ecografía.
- Segundo trimestre: biometría (DBP, CC, fémur) con error ±1–2 semanas; 3.er trimestre poco confiable (±3 semanas), el cerebelo ayuda si hay RCF.
- Altura uterina: el fondo llega al pubis a las 12 semanas, al ombligo a las 20 y entre 20 y 32 semanas mide ~semanas en cm; orienta pero no data.
- La EG correcta es clave para diagnosticar RCF, parto prematuro y embarazo prolongado (≥41 semanas → interrupción).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 90

Paciente con antecedente de reglas irregulares, que ocurren cada 45 a 60 días, se realiza un test de embarazo que resulta positivo. Refiere una FUR segura hace 6 semanas y se solicitó una hCG plasmática de 25.000 UI/L, que corresponde a una edad gestacional entre 6 y 7 semanas. **¿Cuál es la forma ideal para determinar la edad gestacional en esta paciente?**

A FUR segura

B Medición de la altura uterina

C Determinación de hCG plasmática en 48 horas

D Medición ecográfica del saco gestacional

E Medición ecográfica de la longitud cráneo-nalgas

Respuesta E. Con ciclos irregulares la FUR no es confiable, aunque la paciente la recuerde con seguridad. El mejor método es la ecografía precoz, y en el primer trimestre (hasta las 14 semanas) manda la longitud cráneo-nalgas, con error de pocos días. El saco gestacional es menos preciso; la hCG y la altura uterina no sirven para datar el embarazo.

▶ VER CLASE 3.01.3.004 Lactancia

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.4 · Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)

QUÉ HAY QUE SABER

- Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementada hasta los 2 años o más; reduce diarrea, otitis, neumonía y muerte súbita, y en la madre el cáncer de mama y ovario.
- Fomento: apego piel a piel y amamantamiento en la primera hora, alojamiento conjunto, libre demanda, sin chupetes ni relleno en los primeros días; evaluar acople (boca abierta, labio inferior evertido, más areola visible arriba).
- Contraindicaciones maternas: VIH (en Chile se suspende), HTLV-1/2, TBC bacilífera activa no tratada (separar transitoriamente), quimioterapia, drogas ilícitas; del lactante: galactosemia clásica.
- No contraindican: mastitis, hepatitis B (con vacuna + inmunoglobulina al RN), hepatitis C, la mayoría de antibióticos y antihipertensivos.
- Problemas frecuentes: grietas (corregir acople), congestión (vaciamiento, frío/calor), mastitis (cloxacilina sin suspender la lactancia); la lactancia exclusiva con amenorrea es anticonceptiva los primeros 6 meses (MELA).
- Suplemento del lactante: vitamina D 400 UI/día desde el mes hasta los 12 meses; hierro 1 mg/kg/día desde los 4 meses (prematuro 2–3 mg/kg desde los 2 meses).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 55

Puérpera en su décimo día posparto, con PCR para SARS-CoV-2 positiva y síntomas leves. **¿Cuál es la conducta respecto a la lactancia?**

A Suspender la lactancia hasta completar 10 días de aislamiento

B Mantener la lactancia con uso de mascarilla

C Extraer la leche y pasteurizarla antes de dársela al bebé

D Suspender la lactancia y cambiar a fórmula

E Mantener la lactancia sin restricciones

Respuesta B. La COVID-19 materna no contraindica la lactancia: el virus no se transmite por la leche y la lactancia protege al lactante. Se mantiene con medidas para evitar el contagio respiratorio: mascarilla, higiene de manos y de mamas. Suspenderla o pasteurizar la leche no tiene beneficio.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 68

Una paciente es diagnosticada de Covid-19, con inicio de síntomas hace 10 días, mientras cursaba un embarazo de término, manteniendo solo algún grado de tos. Presentó parto vaginal hace dos horas, con recién nacido sano y su puerperio inmediato ha sido normal hasta ahora. ¿Qué recomendación se debe dar acerca del momento en el que se debe iniciar la lactancia materna?

A Posponerla hasta tener la madre una PCR SARS-Cov2 negativa

B Posponerla hasta que se hayan cumplido 14 días desde el diagnóstico

C Posponerla hasta que se hayan cumplido 28 días desde el diagnóstico

D Iniciarla de inmediato con mascarilla

E Iniciarla de inmediato sin protección

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Posponerla hasta que se hayan cumplido 28 días desde el diagnóstico). :::note Dopamina inhibe la prolactina → antidopaminérgicos (antipsicóticos) pueden causar galactorrea incluso en no embarazadas.

▶ VER CLASE 3.01.3.005 Manejo de la salud de la mujer climatérica

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.12 · Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos

QUÉ HAY QUE SABER

- Control de salud de la mujer climatérica (desde ~45 años): pesquisar síntomas con escala MRS, factores de riesgo cardiovascular, osteoporosis, cánceres ginecológicos y salud mental.
- Tamizaje: PA, IMC y perímetro de cintura, glicemia y perfil lipídico, mamografía cada 2 años (50–69 GES), PAP o test VPH según programa, densitometría desde los 65 o antes con factores de riesgo.
- Estilo de vida: actividad física regular, dieta con calcio (1.200 mg/día) y vitamina D (800 UI/día), dejar de fumar, alcohol moderado, control de peso.
- TRH indicada para síntomas moderados a severos dentro de la ventana (<60 años o <10 años de menopausia): estrógeno + progestágeno si tiene útero, estrógeno solo si no; vía transdérmica si hay riesgo trombótico.
- Síndrome genitourinario: estrógeno vaginal local y lubricantes, seguros incluso en la mayoría de las pacientes con contraindicación sistémica.
- Revisar anticoncepción hasta 12 meses de amenorrea (>50 años) y reevaluar anualmente riesgos y beneficios de la terapia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 54 años, menopáusica desde hace 3 años, con bochornos intensos y sudoración nocturna que alteran su sueño. No tiene antecedentes de trombosis ni cáncer, su mamografía reciente es normal, y conserva su útero. **¿Cuál es la terapia de reemplazo hormonal más adecuada?**

A Estrógeno solo, por vía oral

B Estrógeno más progestágeno

C Progestágeno solo, a dosis altas

D Venlafaxina, evitando toda hormona

E Estrógeno tópico vaginal exclusivamente

Respuesta B. Paciente dentro de la ventana de oportunidad (menor de 60 años, menos de 10 años desde la menopausia), sin contraindicaciones y con útero intacto: el esquema correcto es estrógeno más progestágeno, para proteger el endometrio.

▶ VER CLASE 3.01.3.006 Métodos naturales para la regulación de la fecundidad

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.8 · Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Métodos basados en la abstinencia periódica en el período fértil: calendario (Ogino-Knaus), temperatura basal, moco cervical (Billings) y sintotérmico; requieren ciclos regulares y motivación de la pareja.
- Calendario: período fértil desde el ciclo más corto − 18 hasta el ciclo más largo − 11 (registro de 6–12 ciclos). Temperatura basal: alza de 0,3–0,5 °C tras la ovulación; infértil desde el 3.er día de alza.
- Moco cervical: filante, transparente y elástico (clara de huevo) en el período fértil; abstinencia hasta 4 días después del día cúspide.
- MELA: lactancia exclusiva, amenorrea y <6 meses posparto, con >98% de eficacia mientras se cumplan las tres condiciones.
- Eficacia menor que los métodos modernos (falla con uso típico ~15–25%); no protegen de ITS; poco confiables con ciclos irregulares, posparto, perimenopausia o adolescencia.
- El coito interrumpido no se recomienda como método por su alta tasa de falla; ofrecer consejería sobre métodos más eficaces y anticoncepción de emergencia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 28 años, con ciclos regulares, que por convicciones personales desea usar un método natural de regulación de la fecundidad. Le explican uno basado en que ella reconozca diariamente los cambios del moco cervical, que se vuelve abundante, transparente y elástico en el período fértil. **¿A qué método corresponde?**

A Método del calendario (Ogino-Knaus)

B Coito interrumpido

C Método de la temperatura basal

D Método de la lactancia y amenorrea (MELA)

E Método de la ovulación (Billings)

Respuesta E. El método de Billings identifica el período fértil por la autoobservación del moco cervical, que con el alza estrogénica preovulatoria se vuelve filante y transparente. El calendario usa la duración de ciclos previos y la temperatura basal detecta el alza térmica posovulatoria por progesterona. Todos tienen alta tasa de falla con uso típico.

▶ VER CLASE 3.01.3.007 Mortalidad perinatal y materna

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.7 · Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

QUÉ HAY QUE SABER

- Mortalidad materna: muerte durante el embarazo o hasta 42 días tras su término por causa relacionada o agravada por el embarazo; se expresa por 100.000 nacidos vivos.
- En Chile es baja en el contexto latinoamericano y se debe principalmente a enfermedades concurrentes (preexistentes), síndrome hipertensivo del embarazo, aborto y hemorragias; edad materna avanzada es un factor creciente.
- Mortalidad perinatal: mortinatos (muerte fetal tardía) + muertes neonatales precoces (primeros 7 días) por 1.000 nacimientos; refleja la calidad de la atención obstétrica y neonatal.
- Causas perinatales principales: malformaciones congénitas, prematurez y sus complicaciones, asfixia, insuficiencia placentaria y RCF.
- Estrategias preventivas: control prenatal precoz, atención profesional del parto (>99% institucional en Chile), detección y derivación del alto riesgo, planificación familiar y regionalización perinatal.
- Toda muerte materna se notifica y se audita para identificar causas evitables.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

El equipo de estadísticas de un Servicio de Salud debe calcular la mortalidad materna regional del último año, considerando las muertes de mujeres durante el embarazo o dentro de los 42 días siguientes a su término, por causas relacionadas con este o agravadas por él. **¿Cuál es el denominador utilizado para calcular la razón de mortalidad materna?**

A Nacidos vivos, expresado por 100.000

B Mujeres en edad fértil

C Total de embarazos registrados

D Total de partos atendidos, por 1.000

E Población femenina total

Respuesta A. La razón (habitualmente llamada tasa) de mortalidad materna se calcula como muertes maternas dividido por nacidos vivos del mismo período y lugar, por 100.000. Se usa nacidos vivos porque el total de embarazos no se conoce con exactitud. Incluye muertes hasta 42 días posparto por causas obstétricas directas o indirectas.

▶ VER CLASE 3.01.3.008 Anticoncepción

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.8 · Anticoncepción y Planificación Familiar: Criterios Médicos de Elegibilidad OMS y Píldora de Emergencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Criterios de elegibilidad OMS: categoría 1 sin restricción a 4 riesgo inaceptable. El estrógeno es categoría 4 en fumadora ≥35 años con ≥15 cigarrillos/día, migraña con aura, TVP/TEP actual o previa, trombofilia, HTA severa, cáncer de mama actual, lactancia <6 semanas y hepatopatía activa.
- Métodos reversibles de larga duración (LARC) son los más eficaces: implante de etonogestrel (3 años, el de menor falla), DIU-LNG (5–8 años, reduce sangrado) y DIU de cobre (10–12 años, sin hormonas).
- Solo progestágeno (desogestrel 75 µg continuo, inyectable trimestral, implante, DIU-LNG) es seguro cuando el estrógeno está contraindicado y en lactancia; el inyectable puede retrasar el retorno de la fertilidad.
- Combinados (ACO, parche, anillo, inyectable mensual): inhiben la ovulación; beneficios en dismenorrea, SOP y acné; la vía no cambia las contraindicaciones del estrógeno.
- Anticoncepción de emergencia: levonorgestrel 1,5 mg dosis única dentro de 72 h (no es abortivo); ulipristal hasta 120 h; DIU de cobre hasta 120 h, el más eficaz. Repetir dosis si vomita antes de 2 h.
- Ley 20.418 garantiza información y acceso a métodos, incluida la anticoncepción de emergencia para adolescentes; doble protección con preservativo para prevenir ITS.

PREGUNTAS · 11

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 19

Mujer de 22 años, nulípara, con antecedente de migraña a repetición y un episodio de amaurosis fugax, desea iniciar un método anticonceptivo. Su examen físico es normal. **¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos indicaría a esta paciente?**

A Anticonceptivos combinados por vía oral

B Anticonceptivos combinados por vía transdérmica

C Salpingoligadura

D Dispositivo intrauterino con progestágeno

E Anticonceptivos combinados inyectables

Respuesta D. La migraña con aura, aquí manifestada como amaurosis fugax, es categoría 4 para cualquier método con estrógeno. El DIU con progestágeno es la opción segura, a pesar de que la nuliparidad sea una contraindicación relativa menor del dispositivo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 172

Mujer de 20 años, nuligesta, tuvo relaciones sexuales sin protección hace 72 horas y consulta por anticoncepción de emergencia. **¿Cuál es la más efectiva?**

A Levonorgestrel 0,75 mg por una vez

B Levonorgestrel 0,75 mg ahora y otra dosis en 12 horas

C Método de Yuzpe

D Anillo vaginal

E Dispositivo intrauterino de cobre

Respuesta E. Dentro de las 120 horas postcoito, el DIU de cobre es el método de anticoncepción de emergencia más eficaz que existe, con una eficacia sobre el 99 %, muy superior al levonorgestrel oral.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 45

Paciente con un hijo de 8 meses, aún en lactancia materna exclusiva, consulta por el método anticonceptivo más adecuado. **¿Cuál es el método anticonceptivo más adecuado?**

A Anticonceptivos orales combinados

B Dispositivo intrauterino con levonorgestrel

C Anillo vaginal mensual

D Parche anticonceptivo transdérmico

E Implante subdérmico de etonogestrel

Respuesta B. A los 8 meses postparto, ya pasadas las primeras 6 semanas, el DIU con levonorgestrel es una excelente opción de larga duración, sin estrógeno, compatible con la lactancia y sin afectar el volumen de leche.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 37 años, fumadora de 20 cigarrillos al día desde los 18 años, solicita el mismo anticonceptivo combinado de etinilestradiol con drospirenona que usa su amiga. No tiene otros antecedentes y su presión arterial es 125/80. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar el anticonceptivo combinado solicitado

B Denegar el combinado y ofrecer un método solo progestágeno o DIU de cobre

C Indicar el mismo combinado, pero en dosis reducida de estrógeno

D Indicar el combinado por vía transdérmica en parche

E Indicar el combinado por anillo vaginal

Respuesta B. Ser fumadora de 35 años o más con 15 o más cigarrillos al día es categoría 4 de la OMS para cualquier método con estrógeno, sin importar la vía de administración. Se debe ofrecer un método de solo progestágeno o el DIU de cobre.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 44

Paciente que tuvo relaciones sexuales hace 96 horas sin protección, solicita anticoncepción de emergencia. ¿Qué indicar?

A Mifepristona 200 mg vía oral dosis única

B DIU de cobre inmediato

C Ulipristal acetato 30 mg vía oral

D Levonorgestrel 0,750 mg cada 12 horas vía oral

E Etinilestradiol 50 mcg + levonorgestrel (Yuzpe)

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Levonorgestrel 0,750 mg cada 12 horas vía oral). Levonorgestrel 0,750 mg cada 12 horas vía oral.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 171

Una mujer de 36 años, multípara de 3, con su último parto hace 3 años, tiene antecedente personal de cáncer de mama, que fue adecuadamente tratado hace 1 año. ¿Qué método de planificación familiar debe utilizar?

A Anticonceptivos orales combinados, con microdosis de estrógeno

B Anticonceptivos orales con estrógeno solo

C Progestágeno inyectable

D Anillo vaginal con progestágeno

E Dispositivo intrauterino

Respuesta E. Por tener antecedente personal de cáncer de mama tiene absolutamente contraindicados todos los métodos hormonales. El DIU es la indicación.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 10

Anticoncepción en mujer con HTA reciente diagnóstico IMC 34 que tomaba ACO combinado hace 10 años:

A Estrógenos vo

B Estrógenos intradérmicos c. Progestágenos vo

D Reducir dosis estrógenos

E Anillo vaginal SIIII YO PUSE ESO

E Hemograma y VHS

Respuesta B. Diagnóstico: Estrógenos intradérmicos c. Progestágenos vo (opción B).

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 164

Una paciente de 23 años, usuaria de anticonceptivos orales, desde hace 8 meses, consulta por cefalea intensa premenstrual, de 3 meses de evolución, y que dura hasta el segundo día de la menstruación. Su examen físico y neurológico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Anticonceptivos combinados orales de ciclo extendido

B Anticonceptivos combinados con menor dosis de estrógeno

C Anticonceptivos combinados con menor dosis de progestágeno

D Indicar anticonceptivos orales de progestágeno solo

E Indicar anticonceptivos combinados inyectables

Respuesta A. Tiene una cefalea que aparece al suspender los estrógenos (cefalea catamenial), por lo que se debe usar un esquema continuo (sin días de descanso) o bien los ACO de ciclo extendido, que mantienen cierta dosis de estrógeno durante todo el ciclo. Los anticonceptivos inyectables también parecen una opción razonable para ese fin (en especial los trimestrales de progestágeno puro), pero producen aumento de peso y problemas menstruales. Otra forma es bajar la dosis de estrógeno y reducir los días de...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 79

Una paciente de 30 años, multípara de 2, con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento, es usuaria de DIU desde hace 8 años y presenta hipermenorrea y dismenorrea de 8 meses de evolución, por lo que quiere cambiar de método anticonceptivo. ¿Cuál de las siguientes opciones es de elección?

A DIU medicado con progestágeno

B Anticonceptivos orales combinados

C Anillo vaginal combinado

D Progestágenos inyectables cada 3 meses

E Estrógeno solo

Respuesta A. El DIU medicado no produce la hipermenorrea y dismenorrea del DIU común. Además, tiene el mejor perfil cardiovascular, en relación a los métodos hormonales.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 171

Una mujer de 32 años, con antecedente de parto hace 8 meses, sigue dando lactancia materna a su hijo y se ha mantenido en amenorrea. No quiere embarazarse todavía, por lo que pregunta cuál es el método anticonceptivo de elección:

A Amenorrea de la lactancia

B Anticonceptivos orales combinados de etinilestradiol y dienogest

C Anticonceptivos en parches de norelgestromina y etinilestradiol

D Anticonceptivos inyectables de medroxiprogesterona y estradiol

E Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel). 1.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 78

Una paciente de 28 años, con antecedente de IMC: 29 y resistencia a la insulina, usuaria de DIU desde hace 5 años, presenta reglas abundantes y dismenorrea, por lo que solicita cambiar a anticoncepción oral. ¿Cuál de las siguientes opciones es la de elección?

A Etinilestradio 0,02 mg, más drospirenona 3 mg

B Etinilestradio 0,03 mg, más gestodeno 75 ug

C Etinilestradio 0,03 mg, más dienogest 3 mg

D Estradiol 2 mg, más dienogest 2 mg

E Gestodeno 75 ug

Respuesta C. [Pregunta disputada] Pregunta muy discutible, pero el ACO que controlar mejor el sangrado, de los que ahí están sería los que tienen etinilestradiol (en lugar de estradiol) con dienogest, que, además, tiene un excelente perfil cardiovascular. Es una pregunta que excede lo que debe saber un médico general

▶ VER CLASE 3.01.3.009 Prevención de enfermedad hemolítica perinatal

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.20 · Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada

QUÉ HAY QUE SABER

- Enfermedad hemolítica perinatal: madre Rh(–) expuesta a sangre fetal Rh(+) produce IgG anti-D que en embarazos siguientes cruzan la placenta y hemolizan (anemia, hidrops, ictericia).
- Tamizaje: grupo, Rh y Coombs indirecto a toda embarazada en el 1.er control; en Rh(–) no sensibilizada se repite el Coombs indirecto a las 28 semanas.
- Profilaxis: inmunoglobulina anti-D 300 µg IM a las 28 semanas y otra dosis dentro de 72 h posparto si el RN es Rh(+) (Coombs directo del RN negativo).
- También dentro de 72 h tras aborto, ectópico, mola, metrorragia, trauma abdominal, amniocentesis, biopsia de vellosidades o versión externa.
- Coombs indirecto positivo (ya sensibilizada): la anti-D no sirve; titular anticuerpos (crítico 1/16–1/32) y derivar para Doppler de arteria cerebral media (velocidad alta = anemia) y eventual cordocentesis con transfusión intrauterina.
- Coombs directo en el RN detecta anticuerpos unidos a sus glóbulos rojos.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 74

Primigesta de 13 semanas. Su determinación de grupo sanguíneo se informa como AB, Rh negativo, D-u positivo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar Doppler de arteria cerebral media fetal

B Solicitar Coombs indirecto a las 18 semanas

C Administrar Rhogam a las 28 semanas

D Determinar grupo y Rh del padre

E Mantener control habitual del embarazo

Respuesta E. Un D-u positivo indica que la paciente en realidad expresa el antígeno D de forma débil, y se maneja como Rh positivo: no necesita Coombs seriado ni inmunoglobulina anti-D, sino el control habitual del embarazo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Primigesta de 28 semanas, Rh negativa, con Coombs indirecto negativo en este control. Su pareja es Rh positiva. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Administrar inmunoglobulina anti-D, trescientos microgramos intramuscular

B Iniciar titulación seriada de anticuerpos, porque ya está sensibilizada

C Solicitar Doppler de arteria cerebral media de inmediato

D No indicar nada hasta el parto

E Realizar cordocentesis diagnóstica

Respuesta A. Rh negativa no sensibilizada, con Coombs indirecto negativo a las 28 semanas: corresponde la dosis antenatal de rutina de inmunoglobulina anti-D. La titulación, el Doppler y la cordocentesis son solo para la paciente ya sensibilizada.

▶ VER CLASE 3.01.3.010 Prevención de enfermedades de transmisión sexual

DÓNDE SE ENSEÑA **Infectología** 3.5 · Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH

QUÉ HAY QUE SABER

- Prevención combinada: preservativo en todas las relaciones (doble protección junto al anticonceptivo), reducción del número de parejas, educación sexual y consejería.
- Vacunas: VPH nonavalente en escolares de 4.º y 5.º básico (programa nacional) y hepatitis B en el calendario del lactante y grupos de riesgo.
- Testeo: VIH (ELISA o test rápido con consentimiento, confirmación ISP), VDRL/RPR, hepatitis B y C en poblaciones de riesgo y en toda embarazada.
- VIH: TARV como prevención (indetectable = intransmisible), PrEP (tenofovir/emtricitabina) en alto riesgo y PEP dentro de 72 h tras exposición de riesgo (28 días).
- Ante una ITS: tratar a la persona y a sus parejas (gonococo/Chlamydia: contactos de los últimos 60 días), abstinencia 7 días y tamizaje de otras ITS; notificación obligatoria de sífilis, gonorrea y VIH.

- Sífilis congénita: tamizaje con VDRL en el 1.er control, 24–28 semanas y parto, y tratamiento con penicilina benzatina a la madre y la pareja.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Joven de 19 años, que inició actividad sexual hace un año y ha tenido 3 parejas, consulta en el CESFAM porque quiere saber cómo prevenir infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Usa anticonceptivos orales combinados. **¿Cuál es la medida más eficaz para prevenir la transmisión sexual de estas infecciones?**

A Mantener los anticonceptivos orales combinados

B Uso correcto y consistente del preservativo en cada relación

C Ducha vaginal después de cada relación

D Antibiótico profiláctico después de cada relación sexual

E Cambiar a un dispositivo intrauterino de cobre

Respuesta B. El preservativo, usado de forma correcta y en todas las relaciones, es el método de barrera que reduce eficazmente la transmisión del VIH y de la mayoría de las ITS. Los anticonceptivos hormonales y el DIU previenen embarazo, pero no ITS. Se complementa con vacunación contra VPH y hepatitis B y testeo periódico.

▶ VER CLASE 3.01.3.011 Pubertad (adolescencia)

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.1 · Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

QUÉ HAY QUE SABER

- Pubertad femenina normal entre 8 y 13 años; secuencia: telarquia (primer signo) → pubarquia → estirón puberal → menarquia (~2–3 años tras la telarquia, edad media ~12 años).
- Pubertad precoz: caracteres sexuales antes de los 8 años en niñas; central (por GnRH, la mayoría idiopática en niñas) vs periférica; estudiar edad ósea, LH/FSH, estradiol y RM si es central.
- Pubertad retrasada: sin telarquia a los 13 años o sin menarquia a los 15 (o 3 años tras la telarquia); causas: constitucional, hipogonadismo hipogonadotropo (Kallmann, anorexia, deporte) o hipergonadotropo (Turner).
- Los primeros ciclos tras la menarquia suelen ser anovulatorios e irregulares; sangrado abundante en la adolescente obliga a descartar von Willebrand.
- Control de salud adolescente: confidencialidad, evaluación psicosocial (HEADSSS), consejería en sexualidad y anticoncepción, prevención de ITS y embarazo, vacuna VPH.
- Derivar a endocrinología o ginecología infantojuvenil ante pubertad precoz, retrasada o amenorrea primaria.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 32

Una paciente de 14 años aún no ha tenido su menarquia. Presenta desarrollo puberal Tanner 2, mamario y pubiano, con vello axilar. No tiene otras alteraciones en el examen físico. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar ecografía ginecológica

B Solicitar cariotipo

C Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, LH y FSH

D Realizar prueba de progesterona

E Controlar en un año

Respuesta E. A los 14 años, con desarrollo puberal ya iniciado, todavía no se cumple la definición de amenorrea primaria, que exige ausencia de menarquia a los 15 años cuando hay caracteres sexuales secundarios presentes. La conducta correcta es controlar la evolución, no estudiar.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 89

Paciente de 14 años, con menarquia a los 13 años, presenta ciclos menstruales que varían entre 26 y 35 días. Su examen físico es normal y no refiere otros síntomas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar anticonceptivos orales

B Iniciar estrógenos solos por vía oral

C Iniciar progestágenos solos por vía oral

D Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, progesterona, LH y FSH

E Controlar ambulatoriamente con calendario menstrual

Respuesta E. En los primeros años tras la menarquia el eje hipotálamo-hipófisis-ovario aún es inmaduro y los ciclos anovulatorios e irregulares son esperables. Ciclos entre 21 y 45 días son normales en adolescentes. Basta educar y controlar con calendario menstrual; no requiere estudio hormonal ni tratamiento.

▶ VER CLASE 3.01.3.012 Salud pública perinatal

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.7 · Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

QUÉ HAY QUE SABER

- Salud pública perinatal en Chile: atención prenatal y del parto casi universal e institucional, con red perinatal regionalizada que deriva el alto riesgo a centros de mayor complejidad.

- Indicadores: mortalidad materna (por 100.000 NV), perinatal, neonatal e infantil (por 1.000 NV), bajo peso al nacer y prematurez; la mortalidad infantil chilena es hoy predominantemente neonatal.
- Programa de Salud de la Mujer y Chile Crece Contigo: ingreso prenatal precoz, evaluación psicosocial (EPsA), visitas domiciliarias, educación prenatal y acompañamiento del desarrollo infantil.
- Garantías GES perinatales: prevención de parto prematuro, analgesia del parto, VIH (prevención de transmisión vertical), hipoacusia y cardiopatías congénitas, retinopatía y displasia del prematuro.
- Prevención: ácido fólico preconcepcional, harina fortificada con ácido fólico, tamizaje de sífilis, VIH, Chagas y hepatitis B, vacunación materna (influenza, dTpa).
- Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) para embarazadas y nodrizas, y tamizaje neonatal de hipotiroidismo y fenilquetonuria.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En las últimas décadas Chile redujo drásticamente su mortalidad infantil gracias al control de la desnutrición y de las infecciones, y hoy tiene tasas cercanas a las de países desarrollados. **¿Qué componente concentra actualmente la mayor parte de la mortalidad infantil en Chile?**

A Mortalidad por enfermedades diarreicas

B Mortalidad postneonatal (28 días a 11 meses)

C Mortalidad neonatal (menores de 28 días)

D Mortalidad por desnutrición

E Mortalidad por accidentes en el hogar

Respuesta C. En Chile, como en países desarrollados, la mayor parte de la mortalidad infantil es neonatal, asociada a prematurez, malformaciones congénitas y afecciones perinatales. Por eso las estrategias actuales apuntan al período perinatal: control prenatal precoz, atención profesional del parto, regionalización neonatal y Chile Crece Contigo.

▶ VER CLASE 3.01.3.013 Screening ginecológico: Papanicolau, mamografía

DÓNDE SE ENSEÑA

Ginecología 20.13 · Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía
Ginecología 20.14 · Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer cervicouterino (GES): PAP cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años; test de VPH desde los 30 años cada 5 años si es negativo; vacuna VPH en 4.º y 5.º básico como prevención primaria.
- PAP alterado: ASC-US/LIEBG en ≥30 años → test VPH (16/18 → colposcopía); LIEAG, ASC-H o AGC → colposcopía en <30 días (GES).
- Cáncer de mama (GES): mamografía bilateral cada 2 años de 50 a 69 años; alto riesgo genético (BRCA, familiar de 1.er grado joven, radioterapia torácica) desde los 30–35 años, con RM.
- BI-RADS: 0 incompleto (ecografía o proyecciones), 1–2 control habitual, 3 control en 6 meses, 4–5 biopsia con aguja gruesa, 6 cáncer confirmado.
- El examen físico de mamas no reemplaza a la mamografía; la ecografía mamaria complementa en mamas densas y en mujeres jóvenes.
- Rol del médico general: tomar el PAP, solicitar mamografía, interpretar informes y derivar oportunamente según resultado.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 172

Una mujer de 34 años, con vacunación completa contra el virus papiloma humano, se realiza un PAP, que es informado como muestra satisfactoria sin presencia de atipías celulares, y una prueba de detección de virus papiloma humano que es informada como positiva para VPH de alto riesgo, serotipo 56. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar refuerzo de la vacunación contra el VPH

B Realizar control de PAP en un año

C Realizar colposcopía

D Repetir el PAP en este momento

E Realizar conización cervical

Respuesta B. A diferencia de los serotipos 16 y 18, que se derivan a colposcopía de manera inmediata por ser los más agresivos, otros genotipos de alto riesgo, como el 56, con un PAP normal, se manejan con observación y control en un año.

▶ VER CLASE 3.01.3.014 Sexualidad, género y diversidad

DÓNDE SE ENSEÑA

Psiquiatría 17.20 · Sexualidad Humana: Respuesta Sexual, Disfunciones Sexuales, Parafilias, Disforia de Género y Diversidad

QUÉ HAY QUE SABER

- Conceptos: sexo asignado al nacer, identidad de género (vivencia interna), expresión de género y orientación sexual son dimensiones independientes; la diversidad no es una patología.
- Atención inclusiva: lenguaje neutro, preguntar nombre y pronombres, confidencialidad, historia sexual sin supuestos (prácticas, parejas, protección) y evitar juicios.
- Ley de Identidad de Género (21.120) permite rectificar sexo y nombre registral desde los 14 años (con representante y tribunal en menores de 18); la Ley 20.609 sanciona la discriminación arbitraria.

- Riesgos a pesquisar en población LGBTIQ+: depresión, ansiedad, suicidio, consumo de sustancias, violencia y barreras de acceso; tamizaje de ITS y VIH según prácticas, y PrEP.
- Salud sexual: consejería en anticoncepción y prevención de ITS, pesquisa de disfunciones sexuales (deseo, excitación, orgasmo, dispareunia) y de violencia sexual o de pareja.
- Derivar a programa de acompañamiento de identidad de género, salud mental o especialista según necesidad; mantener el tamizaje ginecológico según los órganos presentes (PAP en hombres trans con cuello uterino).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Adolescente de 16 años, asignada mujer al nacer, consulta en control de salud. Refiere que se identifica como mujer, se siente cómoda con su cuerpo y desde los 13 años siente atracción afectiva y sexual solo hacia otras mujeres. **¿Qué concepto describe la atracción que relata la paciente?**

A Identidad de género
B Sexo asignado al nacer
C Expresión de género
D Orientación sexual
E Disforia de género

Respuesta D. La orientación sexual es hacia quién se dirige la atracción afectiva y sexual. La identidad de género es la vivencia interna de ser mujer, hombre u otra; la expresión de género, cómo se manifiesta externamente. Ser lesbiana no es un trastorno; la disforia implica malestar por incongruencia con el sexo asignado, ausente aquí.

▶ VER CLASE 3.01.3.015 Síndrome de ovario poliquístico

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.2 · Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- SOP: endocrinopatía más frecuente de la mujer en edad fértil; mecanismo con aumento de pulsos de GnRH (LH > FSH), andrógenos tecales y resistencia insulínica con caída de SHBG.
- Diagnóstico por criterios de Rotterdam (2 de 3): oligo/anovulación, hiperandrogenismo clínico o bioquímico, morfología poliquística ecográfica; en adolescentes no usar la ecografía como criterio.
- Descartar antes: embarazo, hipotiroidismo (TSH), hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal no clásica (17-OH-progesterona) y tumores secretores de andrógenos (virilización rápida).
- Riesgos asociados: síndrome metabólico, DM2, dislipidemia, hígado graso, apnea del sueño, infertilidad, hiperplasia y cáncer de endometrio por estrógeno sin oposición.
- Tratamiento: baja de 5–10% de peso; sin deseo de embarazo, ACO con progestágeno antiandrogénico (± espironolactona para hirsutismo), metformina si hay resistencia insulínica.
- Con deseo de embarazo: letrozol como inductor de ovulación de primera línea (clomifeno alternativa). Tamizaje metabólico con PTGO y perfil lipídico periódico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 157

Mujer de 28 años con amenorrea de 4 meses, hirsutismo, acné y obesidad central. Ecografía: ovarios con múltiples folículos periféricos. Testosterona libre levemente elevada. **¿Cuál es el diagnóstico?**

A Síndrome de ovario poliquístico
B Hiperprolactinemia
C Insuficiencia ovárica prematura
D Síndrome de Cushing
E Hiperplasia suprarrenal congénita

Respuesta A. Amenorrea (disfunción ovulatoria) más hiperandrogenismo clínico y bioquímico, más ecografía con morfología poliquística: se cumplen los tres criterios de Rotterdam. Es la causa más frecuente de amenorrea secundaria en mujeres jóvenes.

▶ VER CLASE 3.01.3.016 Vínculo y apego

DÓNDE SE ENSEÑA **Pediatría** 18.15 · Atención Inmediata del Recién Nacido & Reanimación Neonatal: Algoritmo AAP/AHA, Minuto de Oro y Test de APGAR

QUÉ HAY QUE SABER

- Apego: vínculo afectivo seguro entre el RN y su cuidador principal, base del desarrollo emocional, cognitivo y social del niño.
- Apego precoz: contacto piel a piel inmediato al nacer en RN de término vigoroso (sin separarlo para procedimientos no urgentes) y amamantamiento en la primera hora; luego alojamiento conjunto.
- Factores protectores: acompañamiento en el parto, lactancia materna, padre o pareja involucrados, red de apoyo; de riesgo: depresión perinatal, embarazo no deseado, adolescencia, violencia, consumo de sustancias.
- Pesquisa: escala de Edimburgo para depresión posparto (en el embarazo y a los 2 y 6 meses) y evaluación psicosocial abreviada (EPsA) en el 1.er control prenatal.
- Chile Crece Contigo: talleres prenatales y de crianza (Nadie es Perfecto), visitas domiciliarias y entrega del ajuar; evaluar la díada madre-hijo en el control del niño sano.

- Ante señales de apego inseguro o negligencia, derivar a salud mental, trabajo social y programas de apoyo psicosocial.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Recién nacido de término, de 3.300 g, nace por parto vaginal, vigoroso, llorando y con buen tono. La madre está estable y desea tenerlo consigo. **¿Qué intervención inmediata favorece más el vínculo y el apego temprano?**

A Aspirar de rutina las secreciones orofaríngeas y gástricas

B Bañar al recién nacido antes de entregárselo a la madre

C Trasladarlo a observación en cuna radiante por 2 horas

D Administrar fórmula láctea para prevenir hipoglicemia

E Contacto piel a piel inmediato con su madre e inicio de lactancia en la primera hora

Respuesta E. En el recién nacido vigoroso se recomienda contacto piel a piel inmediato e ininterrumpido y lactancia en la primera hora: favorece el apego, la termorregulación, la estabilidad glicémica y el éxito de la lactancia. Separarlo para baño, observación o aspiración rutinaria no tiene beneficio y lo interrumpe.

Exámenes e imagenología

8 códigos

▶ VER CLASE 3.01.4.001 **Histerosalpingografía** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.7 · Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: estudio del factor tuboperitoneal en infertilidad (permeabilidad tubaria) y de la cavidad uterina (malformaciones, sinequias, pólipos).
- Se realiza en fase folicular temprana (días 7–11 del ciclo, tras la menstruación y antes de la ovulación) para no irradiar un embarazo inicial.
- Hallazgos: prueba de Cotte positiva (contraste pasa a la cavidad peritoneal) = trompa permeable; hidrosálpinx u obstrucción con Cotte negativa = factor tubario.
- Defectos de llenado orientan a pólipos, miomas submucosos o sinequias (Asherman); imágenes uterinas anómalas a útero septado o bicorne.
- Contraindicaciones: embarazo, PIP activo o infección cervical, metrorragia activa, alergia al contraste yodado.
- Con obstrucción tubaria bilateral, la inseminación no sirve: derivar a fertilización in vitro.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 146

Mujer de 38 años consulta porque lleva 2 años intentando embarazarse. Sus reglas son regulares, su examen físico es normal y múltiples exámenes hormonales confirman ciclos ovulatorios. Su pareja tiene un espermiograma normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?**

A Histeroscopía

B Laparoscopía

C Histerosalpingografía

D Niveles plasmáticos de hormona antimülleriana

E Seguimiento folicular ecográfico

Respuesta C. Con la ovulación confirmada y el espermiograma normal, quedan descartados el factor ovulatorio y el masculino. El siguiente pilar a estudiar es el tuboperitoneal, y el examen de elección es la histerosalpingografía.

▶ VER CLASE 3.01.4.002 **Mamografía** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.14 · Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: tamizaje cada 2 años de 50 a 69 años (GES), desde 30–35 en alto riesgo genético, y estudio de nódulo, telorrea hemática o cambios cutáneos en mujeres ≥35–40 años.
- Signos de malignidad: nódulo espiculado o de bordes irregulares, microcalcificaciones finas agrupadas o lineales, distorsión de la arquitectura, asimetría nueva, engrosamiento cutáneo.
- BI-RADS 0: estudio incompleto (complementar con ecografía o proyecciones); 1 negativo y 2 benigno: control habitual.
- BI-RADS 3: probablemente benigno (<2% de riesgo), control en 6 meses; 4 sospechoso y 5 altamente sugerente (>95%): biopsia con aguja gruesa guiada por imagen.
- BI-RADS 6: cáncer ya confirmado por biopsia. En mamas densas y en menores de 35–40 años se prefiere o complementa con ecografía.
- Una mamografía normal no descarta cáncer ante un nódulo palpable sospechoso: igualmente estudiar con ecografía y biopsia.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 166

Una paciente de 47 años acude a control ginecológico, observándose salida de secreción escasa por el pezón a la compresión, que ella no había notado previamente. Se solicita mamografía, que es informada como BI-RADS 2, y ecografía mamaria, que muestra ectasia ductal retroareolar, BI-RADS 2. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Solicitar mamografía con compresión focal
B Realizar control mamográfico en un año
C Solicitar resonancia magnética nuclear de mama
D Indicar mupirocina tópica
E Resolver mediante resección quirúrgica

Respuesta B. BI-RADS 2 es un hallazgo benigno (aquí, ectasia ductal) y se maneja con control habitual en 1 a 2 años. La compresión focal o la resonancia aclaran estudios incompletos o dudosos; BI-RADS 3 se controla en 6 meses y BI-RADS 4 o 5 exige biopsia.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 113

Una paciente de 40 años se realiza una mamografía que reporta BIRADS 0 (insuficiente). Posteriormente, se realiza una ecografía mamaria con resultado BIRADS 2. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Repetir la mamografía en 6 meses
B Repetir la ecotomografía mamaria en 6 meses
C Solicitar una mamografía con compresión lateralizada
D Solicitar una resonancia magnética nuclear de mamas
E Realizar biopsia estereotáxica

Respuesta B. Manejo de Mamografías BIRADS 0: Las mamografías clasificadas como BIRADS 0 requieren estudios adicionales para su evaluación, siendo la ecografía mamaria la técnica de elección. En el caso de las ecografías mamarias BIRADS 2, la lesión es benigna. Sin embargo, se recomienda repetir la ecografía en 6 meses para confirmar su estabilidad. Un ejemplo de lesión BIRADS 2 en la ecografía es el fibroadenoma, que requiere de seguimiento en 6 meses.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 174

redondeadas, agrupadas, catalogadas como mamografía Birrads ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A Realizar biopsia por punción con aguja gruesa
B Solicitar nueva mamografía en un año
C Solicitar nueva mamografía en 6 meses
D Solicitar ecografía mamaria
E Realizar biopsia por punción, guiada por rayos X

Respuesta C. Birrads 3 = lesión de bajo riesgo de malignidad = control en 6 meses, pudiendo ser complementado con una ecografía. Recordemos también el Birrads 4 = lesión sospechosa = biopsia histológica (guiada por rayos X si tumor no palpable; o con aguja gruesa o mamótomo directo, si tumor palpable).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 16

Una paciente de 45 años se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 0, por presencia de opacidades nodulares bilaterales, bien delimitadas. La conducta más adecuada es:

A Control mamográfico en 6 meses
B Ecografía mamaria
C Biopsia estereotáxica
D Biopsia quirúrgica
E Resonancia magnética nuclear de mama

Respuesta B. Birrads 0 = ecografía; Birrads 1 = control en 1 a 2 años; Birrads 2 = control en 1 a 2 años; Birrads 3 = mamografía en 6 meses (se puede complementar con ecografía); Birrads 4 = biopsia estereotáxica (si no es palpable) o con aguja gruesa (si palpable); Birrads 5 = biopsia quirúrgica.

▶ VER CLASE 3.01.4.003 **Ecotomografía obstétrica normal** NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.2 · Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)

QUÉ HAY QUE SABER

- Esquema de rutina en bajo riesgo (Guía Perinatal): 11–14 semanas, 20–24 semanas y 30–34 semanas; más ecografías no mejoran resultados.
- 1.er trimestre: confirma embarazo intrauterino, viabilidad (LCF), número de fetos y corionicidad, edad gestacional por LCN; a las 11–14 semanas translucencia nucal, hueso nasal y Doppler de uterinas.
- 20–24 semanas: anatomía fetal completa (cráneo, columna, corazón, pared, riñones, extremidades), localización placentaria, líquido amniótico y cervicometría transvaginal (normal ≥25 mm).
- 30–34 semanas: crecimiento fetal (peso estimado en percentil 10–90), presentación, placenta y líquido amniótico (normal: bolsillo mayor 2–8 cm o ILA 5–25 cm).
- Hallazgos normales sin seguimiento extra: placenta de inserción baja en el 2.º trimestre se reevalúa a las 32 semanas (la mayoría migra).
- No se corrige la edad gestacional con ecografías tardías si ya existe una precoz.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Primigesta de 12 semanas, sana, sin factores de riesgo, con embarazo único intrauterino y edad gestacional confirmada. Consulta en su control prenatal sobre cuándo se le realizarán las ecografías de rutina durante el embarazo. **¿Cuál es el esquema de ecografías de rutina recomendado para un embarazo de bajo riesgo?**

A Solo una ecografía a las 20 semanas

B Ecografías a las 11 a 14, 22 a 24 y 30 a 34 semanas

C Una ecografía mensual hasta el parto

D Solo ecografía en el tercer trimestre para estimar el peso

E Ecografías a las 7, 20 y 40 semanas

Respuesta B. Según la Guía Perinatal MINSAL, en el embarazo de bajo riesgo se realizan ecografías de rutina a las 11 a 14 semanas (datación, translucencia nucal, Doppler de uterinas), a las 22 a 24 semanas (anatomía fetal y longitud cervical) y a las 30 a 34 semanas (crecimiento, placenta y líquido amniótico). Más ecografías no mejoran los resultados en bajo riesgo.

▶ VER CLASE 3.01.4.004

Ecotomografía obstétrica patológica

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA

Obstetricia 19.2 · Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)
Obstetricia 19.4 · Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

QUÉ HAY QUE SABER

- Translucencia nucal ≥3 mm (o p99) o ausencia de hueso nasal a las 11–14 semanas: riesgo de aneuploidía → consejería y estudio genético (biopsia de vellosidades 11–14 semanas o amniocentesis desde las 15–16).
- Doppler de arterias uterinas con IP >p95 a las 11–14 semanas: riesgo de preeclampsia precoz → aspirina 150 mg nocturna antes de las 16 semanas hasta las 36.
- Cervicometría <25 mm a las 20–24 semanas: riesgo de parto prematuro → progesterona vaginal 200 mg/noche hasta las 36 semanas (cerclaje si además hay antecedente).
- Peso fetal <p10: diferenciar PEG de RCF con Doppler umbilical; >p90: GEG/macrosomía (evaluar diabetes).
- Líquido amniótico: oligoamnios (bolsillo <2 cm, ILA <5) sugiere RPM, insuficiencia placentaria o uropatía; polihidroamnios (bolsillo >8 cm, ILA >25) diabetes, atresia digestiva, gemelar.
- Placenta previa oclusiva confirmada en el 3.er trimestre o malformaciones fetales: derivar a alto riesgo obstétrico/medicina materno-fetal.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 133

Embarazada de 12 semanas, con translucencia nucal aumentada en la ecografía. **¿Cuál es el examen definitivo para confirmar una trisomía 21?**

A Biopsia de vellosidades coriales (11 a 14 semanas)

B Amniocentesis (15 a 20 semanas)

C ADN fetal en sangre materna

D Fetoscopía

E Marcadores séricos maternos (triple marcador)

Respuesta A. A las 12 semanas, la biopsia de vellosidades coriales es el examen invasivo de elección para el cariotipo fetal, dentro de su ventana de las 10 a 14 semanas. La amniocentesis se reserva para después de las 15 semanas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 133

Embarazada de 12 semanas con translucencia nucal aumentada en la ecografía. **¿Cuál es el examen definitivo para confirmar trisomía 21?**

A Biopsia de vellosidades coriales (11 a 14 semanas)

B Amniocentesis (15 a 20 semanas)

C ADN fetal libre en sangre materna (NIPT)

D Fetoscopía

E Marcadores séricos maternos (triple marcador)

Respuesta A. Una aneuploidía se confirma solo con cariotipo fetal obtenido por técnica invasiva. A las 12 semanas corresponde la biopsia de vellosidades coriales (ventana de 10 a 14 semanas); la amniocentesis se realiza desde las 15 semanas. El ADN fetal libre es un tamizaje de alta sensibilidad, pero no diagnóstico; los marcadores séricos también son tamizaje.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 50

Una paciente de 32 años, con un embarazo de 12 semanas, se realiza una ecografía obstétrica que revela una translucencia nucal mayor al percentil 99 y ausencia de hueso nasal. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A Ecogra:a obstétrica de control a las 21 semanas

B Estudio de ADN libre fetal en sangre materna

C Amniocentesis con cariograma de sangre fetal

D Biopsia de vellosidad corial

E Determinación de niveles de alfa-fetoproteína y hCG

Respuesta D. Actualmente, la mejor forma de evaluar genopatías fetales es con el ADN libre fetal en sangre materna, que es un examen seguro y más sensible y específico que la ecografía, razón por la cual muchas recomendaciones internacionales abogan por indicarlo como examen de primera línea y también como examen de segunda línea, si es que se usó otro, dejando los exámenes invasivos (biopsia de vellosidad corial y amniocentesis) únicamente para la confirmación definitiva. Sin embargo, la normativa chilena...

▶ VER CLASE 3.01.4.005 Ecotomografía ginecológica

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.15 · Cáncer de Endometrio y Masa Anexial / Cáncer de Ovario: Diagnóstico y Marcadores

QUÉ HAY QUE SABER

- Vía transvaginal de elección (mejor resolución); transabdominal en vírgenes o masas grandes. Idealmente en fase folicular temprana para evaluar el endometrio en edad fértil.
- Endometrio postmenopáusico: <4–5 mm compatible con atrofia; ≥4–5 mm con sangrado (≥8 mm con TRH; ≥11 mm asintomática) → biopsia endometrial.
- Miomas: nódulos hipoecogénicos bien delimitados (clasificar FIGO); adenomiosis: útero globuloso con miometrio heterogéneo y asimétrico; pólipo: imagen focal hiperecogénica con vaso nutricio.
- Ovario: quiste simple anecoico unilocular (funcional, control en 6–12 semanas); endometrioma en vidrio esmerilado; teratoma con componente graso y calcificaciones; SOP con ≥20 folículos por ovario o volumen >10 mL.
- Signos de malignidad (IOTA): componente sólido, papilas >3 mm, tabiques gruesos, flujo central, ascitis → derivar a ginecología oncológica.
- En urgencia: útero vacío con beta-hCG sobre la zona discriminatoria (ectópico), líquido libre, signo del remolino y ausencia de flujo (torsión).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 28 años, asintomática, con ciclos regulares, se realiza una ecografía transvaginal de control que muestra un quiste en el ovario derecho de 4 cm, unilocular, anecoico, de pared fina, sin tabiques, papilas ni flujo al Doppler. El útero y el ovario izquierdo son normales y el test de embarazo es negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Laparoscopía con quistectomía

B Solicitar CA-125 y resonancia magnética de pelvis

C Control con ecografía transvaginal en 6 a 8 semanas, en la primera fase del ciclo

D Punción ecoguiada del quiste

E Anticonceptivos orales por 6 meses como tratamiento obligatorio

Respuesta C. Un quiste simple (unilocular, anecoico, pared fina, sin papilas ni flujo) menor de 5 cm en edad fértil es casi siempre funcional y se resuelve solo. Se controla con ecografía transvaginal en 6 a 8 semanas, en fase folicular. La cirugía se reserva para persistencia, crecimiento o rasgos sospechosos.

▶ VER CLASE 3.01.4.006 Ecotomografía mamaria

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.14 · Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Primer examen de imagen ante nódulo palpable en mujer <35–40 años, embarazada o en lactancia; complementa a la mamografía en mamas densas o BI-RADS 0.
- Distingue quiste de nódulo sólido: quiste simple (anecoico, pared fina, refuerzo posterior) es benigno y no requiere más estudio.
- Nódulo benigno (fibroadenoma): ovalado, paralelo a la piel (más ancho que alto), bordes circunscritos, homogéneo.
- Signos de sospecha: más alto que ancho, bordes irregulares o espiculados, sombra acústica posterior, hipoecogenicidad marcada, vascularización interna, adenopatías axilares anómalas.
- Se informa con BI-RADS igual que la mamografía (3 control en 6 meses; 4–5 biopsia con aguja gruesa ecoguiada).
- Útil en la mastitis puerperal que no responde para confirmar y guiar el drenaje de un absceso.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 41

Mujer de 45 años con ecografía mamaria informada como BI-RADS 0. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Completar el estudio con mamografía bilateral

B Biopsia core guiada por ecografía

C Control en 6 meses

D Alta y control anual

E Resonancia magnética mamaria de urgencia

Respuesta A. BI-RADS 0 significa estudio incompleto: no se puede categorizar y se debe complementar con otra imagen. En una mujer de 45 años, la ecografía es complementaria de la mamografía, que es el examen base, por lo que se completa con mamografía bilateral antes de decidir biopsia o seguimiento.

▶ VER CLASE 3.01.4.007 Papanicolau

NIVEL EMPLEA INFORME

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.13 · Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizaje de cáncer cervicouterino: cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años (GES); se informa con el sistema Bethesda e incluye la calidad de la muestra.
- Muestra insatisfactoria o sin células endocervicales: repetir; negativo para lesión: control habitual; inflamatorio sin atipias: tratar infección si hay clínica y no repetir antes.
- ASC-US o LIE de bajo grado (NIE I): en ≥30 años test de VPH (16/18 → colposcopía; negativo → control); en <25–30 años repetir citología, por alta regresión espontánea.
- ASC-H, LIE de alto grado (NIE II–III), AGC o sospecha de carcinoma: derivación a colposcopía con biopsia en <30 días (GES).
- Un PAP normal no descarta cáncer si hay lesión visible o sinusorragia: biopsiar directamente.
- Coordinar el resultado con la Unidad de Patología Cervical y asegurar que la paciente acuda a la colposcopía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 31 años, asintomática, se toma su Papanicolau de tamizaje en el CESFAM al cuarto día de su menstruación. El informe dice: muestra insatisfactoria para evaluación, por abundante sangre que oscurece las células. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Colposcopía inmediata

B Test de VPH y conización si resulta positivo

C Control en 3 años, como un Papanicolau normal

D Repetir el Papanicolau fuera de la menstruación, sin relaciones, duchas ni óvulos en las 48 horas previas

E Biopsia endometrial

Respuesta D. Una muestra insatisfactoria no es normal ni anormal: no permitió evaluar las células. Se repite el Papanicolau, idealmente a mitad de ciclo, sin sangrado y sin relaciones, duchas ni óvulos en las 48 horas previas, tomando exocérvix con espátula y endocérvix con cepillo.

▶ VER CLASE 3.01.4.008 HCG cuantitativa

NIVEL INTERPRETA Y EMPLEA

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.11 · Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico
Obstetricia 19.12 · Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento

QUÉ HAY QUE SABER

- La beta-hCG cuantitativa se duplica cada ~48 h en el embarazo intrauterino viable inicial; un alza <35–50% en 48 h o caída sugiere embarazo anormal (ectópico o aborto).
- Zona discriminatoria 1.500–2.000 UI/L: sobre ese valor debe verse saco intrauterino en la ecografía transvaginal; útero vacío = ectópico. Bajo ese valor, repetir hCG en 48 h.
- Metotrexato en ectópico si hCG <5.000 UI/L (con masa <3,5 cm sin latidos); controlar días 4 y 7 (descenso ≥15%) y luego semanal hasta negativizar.
- Valores muy elevados (>100.000) con útero grande sugieren mola; también embarazo múltiple.
- Seguimiento posmola: hCG semanal hasta 3 valores normales seguidos y mensual por 6 meses con anticoncepción; meseta (4 valores en 3 semanas) o alza = neoplasia trofoblástica gestacional.
- Tras un aborto, la hCG puede tardar 2–6 semanas en negativizarse; una cualitativa positiva aislada no confirma restos ni embarazo nuevo.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 27 años, con 5 semanas de amenorrea, consulta por spotting sin dolor. Está hemodinámicamente estable y el abdomen es blando. La beta-hCG cuantitativa es 900 UI/L. La ecografía transvaginal muestra útero sin saco gestacional, anexos normales y sin líquido libre. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Metotrexato intramuscular a dosis única

B Salpingectomía laparoscópica

C Legrado uterino diagnóstico

D Repetir la beta-hCG cuantitativa en 48 horas

E Dar de alta: el útero vacío descarta el embarazo

Respuesta D. Con beta-hCG bajo la zona discriminatoria (1.500 a 2.000 UI/L) es esperable no ver el saco. Se repite a las 48 horas: si se duplica, sugiere embarazo normal; si sube poco, se estanca o hay útero vacío sobre la zona, se sospecha ectópico. Tratar ahora sería prematuro.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 28 años, a quien se le realizó aspiración endouterina por mola hidatiforme completa hace 6 semanas. Está asintomática, usando anticonceptivos orales. Sus controles semanales de beta-hCG cuantitativa en las últimas 3 semanas fueron: 1.250, 1.230, 1.260 y 1.240 UI/L. **¿Cuál es la interpretación y conducta más adecuada?**

A Descenso normal; continuar controles mensuales

B Neoplasia trofoblástica gestacional; etapificar e iniciar quimioterapia

C Nuevo embarazo; ecografía obstétrica

D Resultado falso positivo; suspender el seguimiento

E Mola residual; histerectomía inmediata

Respuesta B. Tras evacuar una mola, la beta-hCG debe caer hasta negativizarse. Cuatro valores en meseta durante 3 semanas (o un alza en 2 semanas) definen neoplasia trofoblástica gestacional: se etapifica y se trata con quimioterapia, habitualmente metotrexato. No es descenso normal ni embarazo, porque usa anticoncepción.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

14 códigos

▶ VER CLASE 3.01.5.001 **Amniocentesis** NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.2 · Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)

QUÉ HAY QUE SABER

- Procedimiento invasivo diagnóstico desde las 15–16 semanas: punción transabdominal ecoguiada para obtener líquido amniótico (cariotipo, microarray, PCR de infecciones).
- Indicaciones: tamizaje alterado de aneuploidía (translucencia nucal ≥3 mm, ADN fetal libre positivo), malformaciones fetales, antecedente de cromosomopatía, sospecha de infección congénita.
- Antes de las 15 semanas el estudio invasivo de elección es la biopsia de vellosidades coriales (11–14 semanas).
- Riesgo de pérdida fetal ~0,1–0,5%; otras complicaciones: RPM, corioamnionitis e isoinmunización.
- Madre Rh(–) no sensibilizada: inmunoglobulina anti-D dentro de 72 h tras el procedimiento.
- Nivel del médico general: identificar la indicación, dar consejería y derivar a medicina materno-fetal; lo realiza el especialista.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Embarazada de 38 años, Rh positivo, con tamizaje de primer trimestre de alto riesgo para trisomía 21 (translucencia nucal aumentada). Hoy cursa 16 semanas y desea un diagnóstico definitivo. **¿Cuál es el procedimiento más adecuado?**

A Cordocentesis

B Biopsia de vellosidades coriales

C Amniocentesis para estudio genético fetal

D Repetir la medición de translucencia nucal

E Ecografía Doppler de arterias uterinas

Respuesta C. El diagnóstico definitivo de aneuploidía requiere estudio invasivo. A las 16 semanas el procedimiento indicado es la amniocentesis, realizable desde las 15 semanas, con riesgo de pérdida cercano a 0,5%. La biopsia de vellosidades se realiza entre las 11 y 14 semanas; la cordocentesis tiene mayor riesgo. En Rh negativas se administra inmunoglobulina anti-D.

▶ VER CLASE 3.01.5.002 **Cesárea** NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.13 · Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones absolutas: placenta previa oclusiva, desproporción céfalo-pélvica, situación transversa, cesárea corporal o 2 o más cesáreas previas, herpes genital activo, VIH con carga viral >1.000, procidencia de cordón, DPPNI con feto vivo.

- Indicaciones frecuentes: falla de progresión o detención del trabajo de parto, registro fetal categoría III, podálica, RCF con Doppler alterado (etapas II–IV), macrosomía severa.
- Profilaxis: cefazolina 2 g EV 30–60 min antes de la incisión (clindamicina + gentamicina si alergia); tromboprofilaxis según riesgo; anestesia regional de preferencia.
- Complicaciones: hemorragia, infección (endometritis, la principal), lesión vesical o intestinal, tromboembolismo; a largo plazo placenta previa, acretismo y rotura uterina.
- Con 1 cesárea segmentaria previa se puede ofrecer prueba de trabajo de parto en condiciones adecuadas (evitar prostaglandinas).
- Nivel del médico general: reconocer la indicación y derivar oportunamente; la realiza el especialista.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Paciente de 32 años, multípara de 2 partos vaginales, cursando embarazo de 34 semanas, asintomática y sin sangrado. La ecografía muestra una placenta previa oclusiva total. Bienestar fetal normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a la vía y momento del parto?**

A Programar cesárea electiva a las 36-37 semanas

B Programar inducción del parto a las 39 semanas

C Permitir parto vaginal con monitorización continua

D Realizar cesárea de urgencia hoy

E Esperar el inicio espontáneo del trabajo de parto

Respuesta A. La placenta previa oclusiva es indicación absoluta de cesárea, ya que el parto vaginal produciría hemorragia masiva. En la paciente estable y sin sangrado se programa cesárea electiva a las 36-37 semanas, antes de que aparezcan contracciones. No hay indicación de cesárea urgente sin sangrado ni compromiso fetal.

▶ VER CLASE 3.01.5.003 Doppler materno-fetal

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA

Obstetricia 19.2 · Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)
Obstetricia 19.4 · Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

QUÉ HAY QUE SABER

- Arteria umbilical: evalúa la resistencia placentaria; es el examen clave para distinguir PEG de RCF y etapificar (IP >p95, diástole ausente, diástole reversa).
- Arteria cerebral media: IP bajo = redistribución (vasodilatación cerebral) en hipoxia; velocidad sistólica máxima elevada (>1,5 MoM) = anemia fetal en isoinmunización.
- Ductus venoso: onda a ausente o reversa indica falla cardíaca fetal e interrupción inmediata.
- Arterias uterinas (materno): IP >p95 a las 11–14 semanas predice preeclampsia precoz y RCF → aspirina antes de las 16 semanas.
- Indicaciones: RCF o feto pequeño, preeclampsia, HTA crónica, diabetes con vasculopatía, embarazo gemelar monocorial, isoinmunización.
- Nivel del médico general: indicar la derivación e interpretar el informe; la realización corresponde al especialista.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Secundigesta de 13 semanas, con antecedente de preeclampsia severa en su primer embarazo, se realiza la ecografía de 11 a 14 semanas: translucencia nucal de 1,8 mm, hueso nasal presente, y Doppler de arterias uterinas con índice de pulsatilidad sobre el percentil 95. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este control?**

A Indicar aspirina 150 mg en la noche

B Solicitar biopsia de vellosidad corial

C Indicar progesterona vaginal 200 mg cada noche

D Solicitar amniocentesis a las 16 semanas

E Mantener el control habitual, sin ninguna intervención

Respuesta A. La translucencia nucal y el hueso nasal son normales: no hay indicación de estudio genético. El Doppler de uterinas alterado, sumado al antecedente de preeclampsia previa, define alto riesgo de preeclampsia precoz, y la intervención con mayor evidencia es la aspirina, iniciada antes de la semana 16.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Embarazada de 34 semanas con feto de peso estimado en percentil 2. Doppler: arteria umbilical con índice de pulsatilidad sobre el percentil 95 con flujo diastólico presente, arteria cerebral media con índice de pulsatilidad bajo el percentil 5, índice cerebro-placentario bajo el percentil 5 y ductus venoso normal. Velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media normal. **¿Qué indica el hallazgo en la arteria cerebral media?**

A Anemia fetal severa

B Insuficiencia cardíaca fetal descompensada

C Hallazgo normal para la edad gestacional

D Malformación vascular cerebral

E Vasodilatación cerebral por hipoxemia (redistribución o centralización del flujo)

Respuesta E. En la insuficiencia placentaria la hipoxemia fetal provoca vasodilatación cerebral para proteger el cerebro: baja el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media y cae el índice cerebro-placentario (redistribución de flujo). La anemia fetal se evalúa con la velocidad sistólica máxima de la cerebral media, no con su pulsatilidad. La descompensación cardíaca se refleja en el ductus venoso alterado.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Embarazada de 33 semanas, con estimación de peso fetal en percentil 8. El Doppler muestra arteria umbilical con índice de pulsatilidad normal, arteria cerebral media normal, y líquido amniótico normal. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?**

A Restricción de crecimiento fetal etapa I; interrumpir a las 37 semanas

B Pequeño para la edad gestacional constitucional; parto a término, entre las 39 y 40 semanas

C Restricción de crecimiento fetal severa; cesárea inmediata

D Sufrimiento fetal agudo; solicitar amniocentesis

E Feto con peso adecuado para la edad gestacional

Respuesta B. Peso en percentil 8 (entre P3 y P10) con Doppler estrictamente normal en todos los vasos: define un PEG constitucional, sin riesgo de hipoxia, con manejo conservador y parto a término.

▶ VER CLASE 3.01.5.004 Drenaje abceso glándula Bartolino

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.10 · Patología Vulvar y Glándula de Bartolino: Quiste vs Absceso de Bartolino y Liquen Escleroso

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: absceso de Bartolino (masa fluctuante, eritematosa y muy dolorosa en el tercio posterior del labio mayor); el quiste asintomático no se drena.
- Técnica de elección: marsupialización (incisión vertical en la cara mucosa vestibular, drenaje y sutura de la pared del quiste a la mucosa con puntos separados), deja un orificio permanente.
- Alternativa: catéter de Word (sonda con balón) que se deja 4 semanas para epitelizar el trayecto.
- La punción o incisión simple tiene recidiva >80%: no es tratamiento definitivo.
- Tomar cultivo del pus; antibióticos si hay celulitis, ITS o inmunosupresión; biopsia en mujeres >40 años o masa sólida.
- Nivel: derivar a especialista para el procedimiento; el médico general hace el diagnóstico, analgesia y derivación.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 34 años, con tres episodios previos de absceso de Bartolino tratados con drenaje simple, consulta de nuevo por dolor y una masa de 4 cm, fluctuante y eritematosa, en el labio mayor derecho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Nueva punción evacuadora con aguja

B Drenaje quirúrgico con marsupialización

C Solo antibióticos orales, sin drenar

D Observación, porque ya se drenó antes

E Vulvectomía simple

Respuesta B. Absceso recurrente de Bartolino: el drenaje simple o la punción ya fallaron antes, por lo que la conducta es el drenaje con marsupialización, que crea un orificio permanente y baja el riesgo de recidiva.

▶ VER CLASE 3.01.5.005 Evaluación anteparto

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.3 · Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal

QUÉ HAY QUE SABER

- Objetivo: detectar hipoxia fetal anteparto; indicaciones: disminución de movimientos fetales, HTA, diabetes, RCF, embarazo prolongado (≥41 semanas), colestasia, RPM.
- Clínica: percepción de movimientos fetales, altura uterina, maniobras de Leopold y auscultación de LCF (110–160 lpm).
- Registro basal no estresante (RBNE): reactivo = ≥2 aceleraciones de 15 lpm por 15 s en 20 min, basal 110–160, variabilidad 6–25, sin desaceleraciones.
- No reactivo a los 20 minutos: prolongar a 40 minutos con estímulo vibroacústico (ciclo de sueño); si persiste, perfil biofísico o Doppler.
- Perfil biofísico (Manning): 8–10 normal; 8 con oligoamnios o ≤6 sugiere hipoxia → derivar/considerar interrupción; ≤4 interrupción inmediata.
- El médico general realiza la evaluación clínica y el RBNE, y deriva los resultados alterados a alto riesgo obstétrico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Embarazada de 36 semanas, sin patología, con controles normales y feto con crecimiento adecuado en la ecografía de las 32 semanas. Pregunta cómo debe vigilar el bienestar de su hijo en las semanas que faltan para el parto. **¿Cuál es la indicación más adecuada?**

A Registro basal no estresante semanal desde ahora hasta el parto

B Perfil biofísico 2 veces por semana

C Doppler de arteria umbilical semanal

D Percepción y registro diario de los movimientos fetales, consultando de inmediato si disminuyen

E Ecografía de crecimiento cada semana

Respuesta D. En el embarazo de bajo riesgo la vigilancia anteparto se basa en los controles habituales y en la percepción materna de los movimientos fetales: ante su disminución debe consultar de inmediato para evaluación con registro basal no estresante. Las pruebas seriadas (RBNE, perfil biofísico, Doppler) se reservan para embarazos de alto riesgo, como RCF, diabetes, SHE o embarazo prolongado.

▶ VER CLASE 3.01.5.006 Evaluación intraparto

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.17 · Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

QUÉ HAY QUE SABER

- Fases: latente hasta 5 cm; activa desde 5 cm con progreso ~1 cm/h; expulsivo desde dilatación completa; alumbramiento <30 min.
- Tacto vaginal: dilatación, borramiento, altura de la presentación (planos de Hodge o De Lee), variedad de posición, estado de membranas y características del líquido amniótico (meconio).
- Partograma para detectar distocias: fase activa <1 cm/h o detención ≥2–4 h con buena dinámica.
- Control de dinámica uterina (3–5 contracciones en 10 min), LCF cada 15–30 min en fase activa y cada 5 min en expulsivo (o monitoreo continuo en alto riesgo); signos vitales maternos.
- Monitoreo: categoría I normal; II vigilar y medidas de reanimación intrauterina; III (sin variabilidad con tardías recurrentes o bradicardia) interrupción urgente.
- Bishop >6 = cuello favorable para inducir con oxitocina; ≤6 madurar antes con misoprostol o balón.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 58

Paciente en fase activa de trabajo de parto de término, con progresión de dos a siete centímetros en dos horas, con buena dinámica uterina y membranas rotas. El registro cardíaco fetal muestra buena frecuencia, buena variabilidad y aceleraciones, sin desaceleraciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable del estado fetal?**

A Registro tipo I

B Registro tipo II

C Registro tipo III

D Registro reactivo

E Variabilidad disminuida

Respuesta A. Buena frecuencia basal, buena variabilidad, aceleraciones y sin desaceleraciones: es un trazado seguro, categoría uno. "Registro reactivo" es el término del registro basal no estresante sin contracciones, no el de un monitoreo intraparto como este.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Primigesta de 41 semanas ingresa para interrupción programada del embarazo. El feto pesa un estimado de 3.400 gramos, con registro reactivo. Al tacto vaginal: cuello en posición posterior, firme, con 0 por ciento de borramiento, orificio cervical cerrado, y la cabeza fetal móvil, sin encajar. El Score de Bishop da un total de 0 puntos. El interno sugiere iniciar de inmediato una infusión de oxitocina. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Iniciar infusión de oxitocina a dosis crecientes, como propone el interno

B Madurar el cuello con misoprostol vaginal o un balón cervical

C Realizar amniotomía antes de cualquier fármaco

D Indicar cesárea electiva sin intentar la inducción

E Administrar tocolíticos y reevaluar en una semana

Respuesta B. Bishop de 0 puntos es un cuello completamente inmaduro. Inducir directo con oxitocina fracasa en la mayoría de los casos y aumenta el riesgo de cesárea. La conducta correcta es madurar el cuello primero, y recién con Bishop mayor a 6 iniciar la oxitocina.

▶ VER CLASE 3.01.5.007 Examen ginecológico, especuloscopia y tacto bimanual

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.9 · Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: control ginecológico, toma de PAP, flujo vaginal, sangrado anormal, dolor pélvico, masa o sospecha de prolapso; explicar, pedir consentimiento y ofrecer acompañante.
- Posición ginecológica con vejiga vacía; inspección vulvar (lesiones, Bartolino, atrofia, liquen) y maniobra de Valsalva para prolapso e incontinencia.
- Especuloscopía: introducir el espéculo oblicuo hacia atrás y rotarlo, visualizar cuello (ectropión, lesiones, secreción por OCE, cuello en fresa) y paredes vaginales; tomar PAP y cultivos.

- Tacto bimanual: dos dedos vaginales y mano abdominal para evaluar cuello (dolor a la movilización = PIP o ectópico), tamaño, posición y movilidad uterina, y anexos (masa, dolor).
- Tacto rectovaginal en sospecha de endometriosis (nódulos en Douglas) o para evaluar parametrios en cáncer cervicouterino.
- Contraindicación relativa: no hacer tacto vaginal en metrorragia del 3.er trimestre hasta descartar placenta previa con ecografía.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 30 años consulta por flujo vaginal anormal. Corresponde además tomar su citología cervical (PAP) de tamizaje. **¿Cuál es la secuencia correcta del examen ginecológico?**

A Inspección de genitales externos, especuloscopia con toma de muestras y luego tacto bimanual

B Tacto bimanual, luego especuloscopia y toma de muestras

C Especuloscopia con abundante lubricante y luego inspección vulvar

D Tacto rectal, luego especuloscopia y finalmente inspección vulvar

E Toma de muestras sin especuloscopia y tacto bimanual

Respuesta A. El examen se inicia con la inspección de genitales externos, sigue con la especuloscopia (idealmente lubricando solo con agua o suero) para visualizar el cuello y tomar muestras de flujo y PAP, y termina con el tacto bimanual. Hacer el tacto antes altera las muestras y el lubricante interfiere con la citología.

▶ VER CLASE 3.01.5.008 Flujo vaginal (pH)

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.9 · Infecciones del Tracto Genital Inferior: Vulvovaginitis (Amsel) y Cervicitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Se mide con tira de pH aplicada en la pared lateral vaginal (no en el cuello ni con sangre o semen, que alcalinizan); pH normal 3,8–4,5.
- pH >4,5: vaginosis bacteriana (flujo gris, test de aminas positivo con KOH, clue cells) o tricomoniasis (flujo espumoso verdoso, protozoos móviles al fresco).
- pH normal (<4,5): candidiasis (flujo en leche cortada, prurito, hifas y levaduras con KOH) o flujo fisiológico.
- Criterios de Amsel para vaginosis (3 de 4): flujo homogéneo, pH >4,5, aminas positivo, clue cells >20%.
- El pH alcalino del líquido amniótico (prueba de nitrazina) apoya el diagnóstico de RPM.
- Secreción purulenta por el OCE con cuello friable indica cervicitis: tomar muestra para gonococo y Chlamydia y tratar dual.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 29 años consulta por flujo vaginal de mal olor de 1 semana. Se toma una muestra con tórula del tercio medio de la pared lateral de la vagina y se aplica sobre una tira de pH, que marca 5,0. Al agregar KOH al 10% a la muestra se libera olor a pescado. **¿Cuál es la interpretación correcta?**

A pH elevado con test de aminas positivo, compatible con vaginosis bacteriana

B El pH es normal y descarta una vaginosis bacteriana

C Es el pH ácido característico de la candidiasis

D La muestra debe tomarse del endocérvix para ser válida

E El test de aminas positivo confirma una tricomoniasis

Respuesta A. El pH vaginal normal es 3,8 a 4,5. Medido en la pared lateral de la vagina, sin moco cervical, sangre ni semen, un pH sobre 4,5 con aminas positivas apoya vaginosis bacteriana (criterios de Amsel). El moco cervical es alcalino y falsea el resultado; la candidiasis tiene pH normal.

▶ VER CLASE 3.01.5.009 Monitorizacion fetal (estresante y no estresante)

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.3 · Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal
Obstetricia 19.17 · Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

QUÉ HAY QUE SABER

- Registro basal no estresante (anteparto): reactivo con ≥2 aceleraciones de 15 lpm x 15 s en 20 min; basal 110–160 lpm, variabilidad 6–25 lpm. No reactivo: prolongar a 40 min y estimular.
- Test de tolerancia a las contracciones (estresante): con oxitocina o estimulación del pezón hasta 3 contracciones en 10 min; positivo si hay desaceleraciones tardías en ≥50% de las contracciones (indica interrupción).
- Contraindicaciones del test estresante: placenta previa, cesárea corporal previa, RPM, riesgo de parto prematuro.
- Intraparto: desaceleraciones precoces benignas (compresión cefálica), variables (compresión de cordón, las más frecuentes), tardías (insuficiencia placentaria) y patrón sinusoidal (anemia fetal grave).
- Categorías: I normal; II indeterminada (vigilar, cambio de posición, hidratación, suspender oxitocina); III anormal (sin variabilidad con tardías o variables recurrentes o bradicardia) → interrupción urgente.
- El médico general instala, realiza e interpreta el monitoreo y deriva o interrumpe según la categoría.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 25

Mujer de 28 años, con embarazo de 30 semanas, consulta angustiada por no percibir movimientos fetales, sin otros síntomas. Su examen físico es normal. Se le solicita un registro basal no estresante de veinte minutos. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este caso?**

A Tranquilizar a la paciente e indicar que mantenga sus controles habituales

B Solicitar perfil biofísico

C Solicitar ecografía obstétrica

D Repetir el registro basal no estresante por veinte minutos más

E Realizar un test de tolerancia a las contracciones uterinas

Respuesta D. El trazado es no reactivo, con mínimas aceleraciones. Antes de subir a un estudio mayor, se prolonga el registro veinte minutos más, cumpliendo así los cuarenta minutos que dan tiempo para superar un eventual ciclo de sueño fetal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 25

Una mujer de 28 años, con embarazo de 30 semanas, consulta angustiada por no percibir movimientos fetales, sin otros síntomas. Su examen físico es normal. Se solicita un registro basal no estresante de 20 minutos, que muestra frecuencia basal normal, solo dos pequeñas desaceleraciones y aceleraciones mínimas, sin ninguna de 15 latidos por 15 segundos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Tranquilizar a la paciente e indicar que mantenga controles habituales

B Solicitar perfil biofísico

C Solicitar ecografía obstétrica

D Repetir registro basal no estresante por 20 minutos más

E Realizar test de tolerancia a las contracciones uterinas

Respuesta D. El registro no es reactivo: para serlo requiere 2 aceleraciones de 15 latidos por minuto y 15 segundos en 20 minutos. Lo primero es prolongarlo 20 minutos más, porque el feto puede estar en sueño fisiológico. Si persiste no reactivo, recién ahí se pide perfil biofísico.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Embarazada de 34 semanas, sin patología conocida, consulta por disminución de movimientos fetales de 6 horas de evolución. Se instala monitor cardiofetal: en los primeros 20 minutos hay frecuencia basal de 140 latidos por minuto, variabilidad de 10, sin desaceleraciones, y ninguna aceleración. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Indicar cesárea por sufrimiento fetal agudo

B Prolongar el registro y aplicar estímulo vibroacústico

C Dar el alta, indicando que el examen es normal

D Solicitar amniocentesis para estudio de madurez pulmonar

E Administrar corticoides de inmediato

Respuesta B. A los 20 minutos, sin aceleraciones pero con basal y variabilidad normales, corresponde prolongar el registro hasta los 40 minutos y estimular al feto para descartar el ciclo de sueño fisiológico, antes de considerar el examen alterado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 58

Disminución de los movimientos fetales de 12 horas de evolución con LCF (+) conducta: a. RBNE

B Test de tolerancia a las contracciones

B Interrupción del embarazo

C Maduración pulmonar y observación

D Cesárea de urgencia

E Inducción del parto

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: (opción A).

▶ VER CLASE 3.01.5.010 **Parto normal** NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.16 · Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Fases: dilatación (latente hasta 5 cm, activa desde 5 cm), expulsivo, alumbramiento (<30 min) y cuarto período (vigilancia estricta 2 h por riesgo de hemorragia).
- Mecanismo: encajamiento y descenso, flexión, rotación interna a occipito-púbica, desprendimiento por deflexión, rotación externa (restitución) y salida de hombros (anterior primero).
- Durante el expulsivo: protección del periné, episiotomía solo selectiva, LCF cada 5 min; pujo dirigido con dilatación completa.
- Manejo activo del alumbramiento obligatorio: oxitocina 10 UI IM/EV tras salida del hombro anterior, tracción controlada del cordón con contratracción suprapúbica y masaje uterino; reduce >60% la hemorragia posparto.
- Revisar placenta completa y canal del parto (desgarros), pinzamiento tardío del cordón (1–3 min) y apego piel a piel en RN vigoroso.
- Hemorragia posparto (>1.000 mL o hipovolemia): 4 T (tono 70%, trauma, tejido, trombina); masaje bimanual, oxitocina, ácido tranexámico 1 g EV; ergometrina contraindicada en hipertensas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Durante un parto vaginal normal, se produce el desprendimiento del hombro anterior del feto. **¿Cuál es el paso inicial del manejo activo del alumbramiento?**

A Administrar metilergonovina intramuscular tras la salida completa de la placenta

B Administrar oxitocina 10 unidades intramuscular de inmediato

C Traccionar el cordón umbilical antes de que el útero se contraiga

D Esperar la salida espontánea de la placenta sin ninguna intervención

E Administrar misoprostol rectal antes del expulsivo

Respuesta B. El manejo activo del alumbramiento parte con oxitocina intramuscular inmediatamente tras la salida del hombro anterior, o dentro del primer minuto de nacido. Luego sigue la tracción controlada del cordón, con contratracción, y el masaje uterino.

▶ VER CLASE 3.01.5.011 Perfil biofisico fetal

NIVEL DERIVAR A ESPECIALISTA

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.3 · Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal

QUÉ HAY QUE SABER

- Evaluación ecográfica más monitoreo de 5 variables, 0 o 2 puntos cada una: RBNE reactivo, movimientos respiratorios (≥1 episodio de 30 s), movimientos corporales (≥3), tono (extensión y flexión) y líquido amniótico (bolsillo ≥2 cm).
- Interpretación: 10/10 u 8/10 con líquido normal = feto sano; 8/10 con oligoamnios = hipoxia crónica, considerar interrupción.
- 6/10: dudoso, repetir en 24 h o interrumpir si es término; ≤4/10: asfixia probable, interrupción inmediata.
- Indicaciones: RBNE no reactivo, RCF, HTA, diabetes, embarazo prolongado, disminución de movimientos fetales.
- Los primeros parámetros en alterarse con la hipoxia aguda son la reactividad y los movimientos respiratorios; el líquido amniótico refleja hipoxia crónica.
- Nivel del médico general: derivar a especialista para su realización e interpretar el informe.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 83

Mujer de 30 años, cursando un embarazo de 40 semanas, consulta por ausencia de movimientos fetales. Se le realiza un perfil biofísico, que resulta 8/10, con oligoamnios. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A Dejar a evolución espontánea

B Interrumpir el embarazo ahora, por cesárea

C Inducir el parto en este momento

D Realizar cesárea al inicio del trabajo de parto

E Inducir el parto a las 41 semanas

Respuesta C. Un perfil biofísico de 8/10 con oligoamnios, en un embarazo ya de término, es indicación de interrumpir por el riesgo de hipoxia progresiva. La cesárea no es obligatoria: al ser un puntaje 8 y no uno crítico, se puede intentar la inducción del parto.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 24

Embarazo a término, 39 semanas con PBF 6/8 con LA 0/2 conducta

A Inducir b. Cesárea

C Eco doppler seriado Según entiendo, era un OHA idiopático, lo que no es malo, pero hay que hacerle eco doppler para ver si hay insuficiencia placentaria, era muy similar a una de un ensayo.. si pero como estaba de termino mejor la interrumpes..., se suelen interrumpir a las 40, tenia 37

C Interrupción del embarazo

D Maduración pulmonar y observación

E Cesárea de urgencia

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Inducir b. Cesárea (opción A). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

▶ VER CLASE 3.01.5.012 Prueba de trabajo de parto

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Obstetricia** 19.17 · Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

QUÉ HAY QUE SABER

- Prueba de trabajo de parto: conducción en fase activa con buena dinámica (oxitocina si es necesario) para evaluar si hay progreso ante sospecha de desproporción céfalo-pélvica relativa o en cesárea anterior.
- Requisitos: presentación cefálica, fase activa, membranas rotas (amniotomía), dinámica adecuada (3–5 en 10 min), monitoreo fetal continuo y posibilidad de cesárea inmediata.
- Se evalúa la dilatación y el descenso a las 2–4 h: progreso = continuar parto vaginal; sin progreso o con signos de DCP (suturas cabalgadas, caput, sin descenso) = cesárea.
- En 1 cesárea segmentaria previa: candidata si no hay otra indicación de cesárea; evitar prostaglandinas (misoprostol) y vigilar signos de rotura uterina (dolor, bradicardia fetal, ascenso de la presentación).
- Contraindicaciones: cesárea corporal o 2 o más previas, rotura uterina previa, placenta previa, presentación anómala, DCP absoluta.

- Suspender ante registro fetal categoría III o sospecha de rotura uterina.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 109

Paciente de 31 años entra en trabajo de parto a las 38 semanas. Al examinarla se constatan 3 contracciones uterinas en 10 minutos y el tacto vaginal muestra 5 cm de dilatación, membranas íntegras y presentación cefálica en espinas -1. El registro de frecuencia cardiaca fetal es normal. Se reevalúa a las 3 horas, sin cambios obstétricos. **¿Cuál es la conducta de elección?**

A Mantener una conducta expectante por 1 hora y reevaluar
B Administrar misoprostol
C Realizar cesárea
D Realizar rotura artificial de membranas y administrar anestesia epidural
E Administrar oxitocina endovenosa en goteo

Respuesta D. Fase activa sin progreso con membranas íntegras: antes de diagnosticar distocia se realiza una prueba de trabajo de parto, optimizando las condiciones con rotura artificial de membranas y analgesia epidural, y luego oxitocina si la dinámica es insuficiente. Si no progresa tras la prueba, se indica cesárea.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 159

Una paciente de 31 años, entra en trabajo de parto a las 37+6 semanas y al exami- narla se constatan 3 contracciones uterinas en 10 minutos y su tacto vaginal myestra 5 cm de dilatación cervical, membranas íntegras y presentación cefálica, en espinas -1. El registro de la frecuencia cardiaca fetal está dentro de rangos normales. Se la evalúa a las 3 horas, manteniéndose sin cambios obstétricos. La conducta de elección es:

A Mantener una conducta expectante por 1 hora y reevaluar
B Realizar fórceps
C Realizar cesárea
D Realizar rotura artificial de membranas y administrar anestesia epidural
E Administrar oxitocina endovenosa en goteo

Respuesta D. Tienen una fase activa lenta, que requiere de una prueba de trabajo de parto (romper membranas, anestesia y goteo oxitócico si las contracciones son menores a 3 en 10 min: no es el caso).

▶ VER CLASE 3.01.5.013 Taponaje vaginal

NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.13 · Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: hemorragia genital aguda por cáncer cervicouterino (cervicorragia), sangrado de lesiones vaginales o desgarros, como medida hemostática transitoria.
- Técnica: posición ginecológica, espéculo y visualización del sitio de sangrado; rellenar el fondo de saco vaginal con compresa o gasa larga (idealmente húmeda o con agente hemostático) en forma ordenada y compresiva.
- Instalar sonda Foley vesical (el taponaje comprime la uretra), registrar el número de compresas y retirarlo en 24–48 h.
- Asociar estabilización hemodinámica (vías gruesas, cristaloides, transfusión si es necesario) y ácido tranexámico.
- Complicaciones: infección (considerar antibiótico profiláctico), retención urinaria, olvido de material.
- Tras el taponaje, derivar urgente a ginecología oncológica para radioterapia hemostática o manejo definitivo.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 48 años, con cáncer cervicouterino etapa IIIB en espera de radioterapia, consulta por metrorragia abundante. Tras volemización está hemodinámicamente estable, pero el sangrado desde el tumor cervical persiste pese a ácido tranexámico endovenoso. **¿Cuál es la medida inmediata más adecuada para controlar el sangrado?**

A Alta con anticonceptivos orales combinados
B Histerectomía radical de urgencia
C Legrado uterino
D Conización cervical
E Taponamiento vaginal compresivo con gasa

Respuesta E. El sangrado de un cáncer cervicouterino avanzado se controla de inmediato con taponamiento vaginal compresivo, habitualmente con sonda Foley, que se retira o recambia en 24 a 48 horas, mientras se coordina radioterapia hemostática o embolización. La cirugía no está indicada en etapa IIIB y el legrado o la conización aumentan el sangrado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 38

Ca cu con sangrado activo q no responde a ac tranexámico: a. Taponamiento vaginal (REPETIDA DE AÑO ANTERIOR)

- B Ligar arterias cervicales
- B Ninguna de las anteriores es correcta
- C Todas las anteriores son correctas
- D No se dispone de información suficiente
- E Otra alternativa no descrita

Respuesta A. La alternativa correcta es la A ().

▶ VER CLASE **3.01.5.014** **Toma de Papanicolau (incluye hacer el frotis)** NIVEL REALIZAR

DÓNDE SE ENSEÑA **Ginecología** 20.13 · Cáncer Cervicouterino (CCU) GES, Lesiones Preinvasoras (Bethesda) y Colposcopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizaje cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años; idealmente fuera de la menstruación, sin duchas vaginales, óvulos ni relaciones sexuales 48 h antes.
- Especuloscopía sin lubricante (o mínimo con agua) para visualizar el cuello y la zona de transformación.
- Toma exocervical con espátula de Ayre girando 360° y endocervical con cepillo (citobrush) girando 180–360°; en la embarazada el cepillo se usa con suavidad o se prefiere solo la espátula.
- Extender en el portaobjetos en capa delgada y uniforme (exocérvix y endocérvix), fijar inmediatamente (alcohol o spray fijador) para evitar artefactos de secado; rotular con datos de la paciente.
- Si se ve una lesión sospechosa no basta el PAP: derivar a colposcopía con biopsia.
- Registrar y asegurar la entrega del resultado; no tomar PAP con metrorragia activa ni infección florida (tratar y luego tomar).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 35 años acude al CESFAM para su citología cervical de tamizaje. No está menstruando y no ha tenido relaciones sexuales ni usado óvulos en las últimas 48 horas. **¿Cuál es la técnica correcta para tomar el PAP?**

- A Muestra solo del fondo de saco vaginal posterior con tórula
- B Muestra de exocérvix con espátula de Ayre y de endocérvix con cepillo, extendido delgado en el portaobjetos y fijación inmediata
- C Tomar la muestra después del tacto bimanual, usando abundante lubricante
- D Extender la muestra y dejarla secar al aire 10 minutos antes de fijarla
- E Extender la muestra en capa gruesa para aumentar la celularidad

Respuesta B. El PAP debe incluir la zona de transformación: exocérvix con espátula de Ayre y endocérvix con cepillo. Se extiende en capa delgada y uniforme y se fija de inmediato, en menos de 10 segundos, para evitar artefactos por desecación. El lubricante, la sangre y el tacto previo alteran la muestra.

21

SALUD PÚBLICA

55 CÓDIGOS

148 PREGUNTAS

SECCIÓN DEL PERFIL	CÓDIGOS
Conocimientos generales	55

Conocimientos generales

55 códigos

▶ VER CLASE **7.01.3.001** **Conceptos y definiciones de Salud Pública**

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.5 · Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- Salud pública (Winslow): ciencia y arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud mediante el esfuerzo organizado de la sociedad; su sujeto es la población, no el individuo.
- Salud: bienestar físico, mental y social, no solo ausencia de enfermedad (OMS). Incluye determinantes sociales, promoción, prevención, organización de servicios y rehabilitación; no se limita al sector estatal ni a las infecciones.
- MAIS (Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria): centrado en las personas, integral (promoción a cuidados paliativos) y con continuidad del cuidado por un equipo de cabecera; la unidad de trabajo es la familia y la comunidad.
- Instrumentos del MAIS: genograma (estructura familiar, ≥3 generaciones), ecomapa (redes de apoyo y aislamiento), APGAR familiar (7-10 normal, 4-6 disfunción leve a moderada, 0-3 severa).
- Diagnóstico de situación de salud (ASIS) del territorio del CESFAM: datos objetivos + diagnóstico participativo con la comunidad, luego priorización y plan de acción.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un médico recién llegado a una Dirección de Salud comunal pregunta en qué se diferencia su nuevo trabajo de la atención clínica que realizaba en el hospital. **¿Qué característica define mejor a la salud pública?**

A Su objeto es el diagnóstico y tratamiento de cada paciente individual

B Su objeto es la salud de la población, mediante esfuerzos organizados de la sociedad

C Es la medicina ejercida exclusivamente en establecimientos estatales

D Se limita al control de enfermedades infecciosas

E Se ocupa principalmente de la gestión hospitalaria

Respuesta B. La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud mediante esfuerzos organizados de la sociedad (Winslow). Su sujeto es la población, no el individuo, e incluye determinantes sociales, promoción, prevención y organización de servicios. No se restringe al sector estatal ni a las infecciones.

▶ VER CLASE **7.01.3.002** **Funciones esenciales de la Salud Pública**

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.1 · Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- Funciones esenciales de salud pública (FESP, OPS): acciones colectivas que el Estado debe garantizar; no son prestaciones clínicas individuales.
- Incluyen monitoreo y análisis de la situación de salud, vigilancia y control de riesgos y daños, promoción de la salud, participación social, políticas y regulación, acceso equitativo a servicios, desarrollo del recurso humano, calidad, investigación y gestión de emergencias.
- En Chile la rectoría (políticas, normas) es del MINSAL con sus subsecretarías (Salud Pública: vigilancia y SEREMI; Redes Asistenciales: Servicios de Salud); la Superintendencia de Salud fiscaliza (autónoma) y el ISP es el laboratorio nacional de referencia.
- Clave de examen: distinguir quién norma (MINSAL), quién administra la red (Servicios de Salud), quién fiscaliza (Superintendencia) y quién financia/asegura (FONASA).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

La Organización Panamericana de la Salud definió las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP), que son responsabilidad indelegable del Estado y permiten evaluar el desempeño de la autoridad sanitaria. **¿Cuál de las siguientes corresponde a una Función Esencial de Salud Pública?**

A Comercialización de seguros de salud

B Realización de cirugías electivas en clínicas privadas

C Monitoreo, evaluación y análisis de la situación de salud de la población

D Fabricación de medicamentos genéricos

E Atención odontológica estética

Respuesta C. Las FESP describen las acciones colectivas que el Estado debe garantizar: monitoreo y análisis de la situación de salud, vigilancia y control de riesgos, promoción de la salud, participación social, políticas y regulación, acceso equitativo, desarrollo del recurso humano, calidad, investigación y gestión de emergencias. Las prestaciones individuales comerciales no forman parte de ellas.

▶ VER CLASE **7.01.3.003** **Historia natural de la enfermedad**

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.10 · Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos

QUÉ HAY QUE SABER

- Historia natural de la enfermedad (Leavell y Clark): período prepatogénico (agente, huésped y ambiente antes de la enfermedad) y patogénico (fase subclínica y luego clínica, con desenlace: curación, secuela, cronicidad o muerte).
- Período de latencia o fase preclínica: la enfermedad ya existe sin síntomas; es la ventana que aprovecha el tamizaje.
- Cada período se asocia a un nivel de prevención: prepatogénico a prevención primaria (promoción, protección específica); subclínico a secundaria (detección precoz); clínico tardío a terciaria (rehabilitación, limitar secuelas).
- Ejemplo: Papanicolaou que detecta lesión de alto grado en mujer asintomática = intervención en fase subclínica (prevención secundaria); la vacuna VPH actúa en el período prepatogénico.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mediante el Papanicolau de tamizaje se detecta una lesión intraepitelial de alto grado en una mujer de 32 años completamente asintomática, que luego es tratada con conización. **Según el modelo de Leavell y Clark, ¿en qué período de la historia natural de la enfermedad se intervino?**

A Período prepatogénico
B Período de secuelas o resultado final
C Período patogénico clínico, con síntomas
D Período patogénico subclínico o presintomático
E Período de convalecencia

Respuesta D. La historia natural de la enfermedad distingue un período prepatogénico (agente, huésped y ambiente antes del inicio) y uno patogénico, subclínico y luego clínico. El tamizaje detecta la enfermedad en la fase subclínica, cuando ya existe pero no da síntomas: es prevención secundaria. La vacuna contra VPH actuaría en el período prepatogénico (prevención primaria).

▶ VER CLASE 7.01.3.004 Niveles de prevención

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.10 · Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos

QUÉ HAY QUE SABER

- Prevención primaria: evita que aparezca la enfermedad; incluye promoción de la salud y protección específica (vacunas, cloración del agua, uso de casco, saneamiento).
- Prevención secundaria: detección y tratamiento precoz en fase preclínica (tamizaje: Papanicolaou, mamografía, tamizaje neonatal de fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito, control de presión arterial).
- Prevención terciaria: limita daño y secuelas de la enfermedad ya establecida (rehabilitación, control de diabéticos para evitar complicaciones).
- La promoción de la salud (Carta de Ottawa) da a la población los medios para controlar sus determinantes, sin dirigirse a una enfermedad específica (ciclovías, ferias saludables, entornos saludables).
- Trampa frecuente: el tamizaje es prevención secundaria; no evita la enfermedad, la detecta antes de los síntomas.

PREGUNTAS · 10

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 176

¿A qué tipo de medida corresponde el tamizaje de TSH y fenilcetonuria que se hace a todos los recién nacidos en Chile? **¿Qué tipo de medida es?**

A Promoción de la salud
B Prevención específica
C Prevención primaria
D Prevención secundaria
E Prevención terciaria

Respuesta D. El tamizaje detecta una enfermedad que ya existe, antes de que dé síntomas: es prevención secundaria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 72

Screening de fenilcetonuria que se hace a todos los recién nacidos en Chile. **¿A qué tipo de medida corresponde?**

A Promoción de la salud
B Protección de la salud
C Prevención primaria
D Prevención secundaria
E Prevención terciaria

Respuesta D. Un tamizaje detecta una enfermedad que ya está presente, antes de que dé síntomas: eso es prevención secundaria. La prevención primaria evitaría que la enfermedad apareciera; aquí la enfermedad ya existe, solo se adelanta el diagnóstico.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 72

Se pregunta a qué tipo de medida corresponde el tamizaje de fenilcetonuria que se hace a todos los recién nacidos en Chile. **¿A qué tipo de medida corresponde este tamizaje?**

A Promoción de la salud
B Protección de la salud
C Prevención primaria
D Prevención secundaria
E Prevención terciaria

Respuesta D. Las pruebas de tamizaje, como la fenilcetonuria neonatal, son prevención secundaria: detectan una enfermedad que ya existe, en su fase preclínica, antes de que produzca síntomas, para tratarla precozmente. No la evitan, como haría la prevención primaria, ni tratan sus secuelas, como la terciaria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 143

¿A qué concepto corresponde la siguiente definición: “Conjunto de medidas destinadas a evitar que una enfermedad ocurra, actuando antes de que exista la enfermedad o el daño causado por esta”?

A Prevención primaria
B Prevención secundaria
C Prevención terciaria
D Prevención cuaternaria
E Promoción de la salud

Respuesta A. Prevención primaria actúa antes de que exista la enfermedad (ej. vacunas con papiloma). Prevención secundaria actúa cuando ya existe la enfermedad, pero todavía no hay síntomas, permitiendo un diagnóstico oportuno (ej. PAP). Prevención terciaria actúa cuando la enfermedad ya Gene síntomas, para recuperar la salud y evitar complicaciones y recidivas (ej. histerectomía radical). Prevención cuaternaria enfrenta los síntomas, en ausencia de una patología orgánica (ej. psicoterapia de trastorno...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 69

¿A qué tipo de medidas corresponde la instalación de las salas IRA (Infecciones Respiratorias Agudas) y salas ERA (Enfermedades Respiratorias del Adulto), durante las campañas de invierno, por parte del Ministerio de Salud?

A Prevención primaria
B Prevención secundaria
C Prevención terciaria
D Promoción de la salud
E Prevención específica

Respuesta C. La enfermedad ya está presente y los pacientes ya tienen síntomas, así que es una medida de prevención terciaria. La primaria es antes de la enfermedad. La secundaria es antes de los síntomas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 170

Desde el año 2005 existe la ley que obliga a los automovilistas a utilizar el cinturón de seguridad con el objetivo de disminuir traumatismos asociados a accidentes. Con respecto a esta ley, en términos de prevención, corresponde a:

A Prevención primaria
B Promoción de salud
C Prevención secundaria
D Prevención tercearia
E Control sanitario

Respuesta A. Diagnóstico: Prevención primaria (opción A). Previene traumatismos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 21

Acude a control una paciente de 26 años, trae el resultado de su papanicolau que es informado como “muestra satisfactoria, sin atipías”. ¿A qué tipo de prevención corresponde este examen?

A Prevención específica
B Promoción de salud
C Prevención secundaria
D Prevención tercearia
E Prevención primaria

Respuesta C. El PAP hace Dg precoz, para tratamiento oportuno. Por tanto es secundaria. La vacunación contra el VPH sí es primaria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 167

¿A que tipo de medida corresponde la vacunación contra una enfermedad, en la historia natural de una enfermedad?

A Promoción de salud
B Protección específica
C Erradicación de la enfermedad
D Diagnóstico oportuno
E Tratamiento precoz

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Protección específica). Es una medida clásica de prevención primaria, de tipo prevención específica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 11

¿Cuál de las siguientes medidas es más eficaz, en el mediano plazo, para disminuir la cantidad de pacientes diabéticos que progresan a necesitar hemodiálisis?

A Screening de glicemia en población de riesgo de diabetes
B Screening de glicemia en población adulta
C Tratamiento eficaz en pacientes diabéticos diagnosticados
D Prevención de factores de riesgo cardiovascular en la población adulta
E Prevención de obesidad en la población de riesgo de diabetes

Respuesta C. Es una pregunta muy rara y muy mala, pero la única respuesta aceptable es la C, ya que es la única medida de prevención terciaria y es la forma en que se plantea la pregunta (evitar complicaciones). La A y B son prevención secundaria. La D y E son prevención primaria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 127

Paciente EPOC TBQ activo, con disnea, se va a hacer un EMPA y la enfermera le hace consejería para que deje de fumar para que mejore la disnea ¿Que tipo de prevención es?

A Prevención 1°
B Prevención 2° c. Prevención 3°
D Promoción de la salud (esta Era prevencion terciaria) segun yo era promocion porque igual depende del caballero si deja de fumar o no entonces no es un acto preventivo perse - Eso mismo e. Prevención 4 Pero da la razon de consejeria, es para mejorar disnea de enfermedad que ya tiene. Era prevencion terciaria porque el paciente ya estaba sintomatico, en fase de rehab.
D Ninguna de las anteriores es correcta
E Todas las anteriores son correctas

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Prevención 1°).

▶ VER CLASE **7.01.3.005** **Promoción de salud y prevención de enfermedades**

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.5 · Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- Promoción de la salud (Carta de Ottawa): proceso que capacita a las personas y comunidades para aumentar el control sobre su salud y sus determinantes; actúa con participación social y entornos saludables, sin focalizarse en una enfermedad.
- Prevención de enfermedades: acciones dirigidas a evitar una enfermedad específica (primaria), detectarla precozmente (secundaria) o limitar secuelas (terciaria).
- Ejemplos chilenos: Elige Vivir Sano, Chile Crece Contigo, Examen de Medicina Preventiva (EMP/EMPAM), Programa Nacional de Inmunizaciones, ley de etiquetado de alimentos y regulación del tabaco.
- Pregunta tipo: municipio que construye ciclovías, plazas activas y ferias saludables = estrategia de promoción de la salud, no prevención primaria específica.
- El médico general en APS integra ambas: consejería breve, EMP, vacunación y derivación a programas comunitarios.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un municipio, junto a vecinos y organizaciones sociales, construye ciclovías y plazas activas, y establece ferias libres con alimentos saludables a bajo costo, para mejorar la calidad de vida de toda la población comunal. **¿A qué tipo de estrategia corresponde esta iniciativa?**

A Prevención cuaternaria
B Prevención primaria específica
C Prevención secundaria
D Prevención terciaria
E Promoción de la salud

Respuesta E. La promoción de la salud (Carta de Ottawa) busca dar a la población los medios para mejorar su salud y controlar sus determinantes, con participación social y entornos saludables, sin dirigirse a una enfermedad específica. La prevención primaria apunta a evitar una enfermedad determinada (por ejemplo, vacunar), la secundaria a detectarla precozmente y la terciaria a limitar secuelas.

▶ VER CLASE 7.01.3.006 Determinantes del nivel de salud

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.5 · Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- Determinantes sociales de la salud (OMS): condiciones en que las personas nacen, crecen, trabajan y envejecen; explican gran parte de las inequidades en salud.
- Estructurales (posición socioeconómica: educación, ingreso, ocupación, género, etnia) pesan más que el acceso a servicios; el nivel educacional es el de mayor impacto en mortalidad y esperanza de vida.
- Intermedios: condiciones materiales (vivienda, trabajo), factores conductuales y biológicos, cohesión social y sistema de salud.
- Modelo de Lalonde: estilo de vida y conducta, biología humana, medio ambiente y organización de la atención sanitaria; el estilo de vida es el de mayor peso.
- Implicancia: la reducción de inequidades requiere políticas intersectoriales (educación, vivienda, empleo), no solo más servicios clínicos.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 51

Según la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, se analizan distintos factores que influyen en la salud de la población. **¿Cuál de los siguientes factores tiene mayor impacto en la salud de la población?**

A Nivel educacional
B Vivienda
C Alimentación
D Ingreso económico
E Acceso a servicios de salud

Respuesta A. Los determinantes estructurales (posición socioeconómica: educación, ingreso, ocupación) pesan más que el acceso a servicios de salud. El nivel educacional se considera el de mayor impacto, porque condiciona el ingreso, el empleo, las conductas y el uso de servicios, y se asocia de forma consistente con mortalidad y esperanza de vida.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 69

¿Cuál de las siguientes enfermedades corresponde con mayor probabilidad a una enfermedad laboral?

A Dermatitis de contacto alérgica
B Asma
C Mesotelioma
D Síndrome del manguito rotador
E Trastorno adaptativo

Respuesta C. Los mesoteliomas son por exposición a asbesto. De todos modos, es una pregunta muy específica y además la frecuencia de mesoteliomas es muy baja en la actualidad (cerraron la empresa Pizarreño hace muchos años: era la que hacía placas de asbesto).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 116

En un gráfico de salud pública se observa que la tasa de mortalidad infantil ha disminuido progresivamente en los últimos 40 años en Chile. ¿Cuál es el principal determinante de esta tendencia?

A Mejoras en condiciones socioeconómicas, educación materna y acceso a agua potable
B Introducción de nuevos antibióticos
C Vacunación masiva universal
D Aumento del número de médicos
E Disminución de la natalidad

Respuesta A. La caída histórica de la mortalidad infantil se atribuye principalmente a determinantes sociales: mejor nivel educacional, condiciones sanitarias, acceso a agua potable y saneamiento, más que a intervenciones médicas aisladas.

▶ VER CLASE 7.01.3.007 Demografía y salud pública

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.15 · Gestión y Administración en Salud: Demografía, Planificación, Programación, Organización y Dirección

QUÉ HAY QUE SABER

- Demografía: estudia tamaño, estructura y dinámica de la población (natalidad, mortalidad, migración); fuentes: Censo, estadísticas vitales (nacimientos y defunciones del Registro Civil/DEIS) y encuestas.
- Pirámide poblacional: base ancha = población joven y alta natalidad; base estrecha y cima ancha = envejecimiento. Chile está en transición demográfica avanzada, con baja natalidad y fecundidad bajo el nivel de reemplazo.
- Transición epidemiológica: predominio de enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer sobre infecciosas, con aumento de la carga en adultos mayores y de la dependencia.
- Índices útiles: índice de envejecimiento (≥65 años por 100 menores de 15), razón de dependencia, tasa bruta de natalidad y de mortalidad, esperanza de vida al nacer.
- Uso en salud pública: dimensionar demanda por grupo etario, planificar la red asistencial y calcular tasas ajustadas por edad para comparar poblaciones.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 138

Si aumenta la velocidad de envejecimiento en la población que pasara en temas de salud publica: **¿Qué ocurre?**

A Aumento de cobertura de adultos mayores en APS
B Aumento de personas con fragilidad
C Aumento en la variabilidad de morbilidad o mortalidad
D Ninguna de las anteriores es correcta
E Todas las anteriores son correctas

Respuesta B. Un envejecimiento poblacional más rápido aumenta el número de personas mayores con pérdida de reserva funcional, es decir, con fragilidad. Por eso el EMPAM busca pesquisarla de forma sistemática en APS.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 13

Una localidad de la zona norte del país experimenta un aumento significativo de migrantes debido a un programa de incentivos laborales y subsidios económicos, el cual exige una permanencia mínima de 5 años y atrae principalmente a parejas jóvenes y niños. **¿Cuál de los siguientes cambios demográficos es esperable?**

A Aumento de la expectativa de vida de la población
B Aumento de la tasa bruta de mortalidad
C Aumento de la tasa bruta de natalidad
D Aumento de la tasa de mortalidad infantil
E Aumento de la prevalencia de cánceres ginecológicos

Respuesta C. La llegada de población joven en edad reproductiva rejuvenece la estructura por edad: aumentan los nacimientos respecto de la población total, elevando la tasa bruta de natalidad, y tiende a bajar la tasa bruta de mortalidad. La esperanza de vida y la mortalidad infantil dependen de las condiciones de vida y atención, no de la estructura etaria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 12

En una zona rural del país se recibe una gran cantidad de migrantes, principalmente personas jóvenes y sanas. Desde el punto de vista de la gestión en salud pública para dicha zona, ¿qué medida debe priorizarse?

A Aumentar los recursos para el programa de enfermedades crónicas
B Aumentar los recursos para los programas de atención materno-infan2l
C Reforzar los programas de saneamiento básico
D Realizar empadronamiento de los migrantes
E Aumentar el número de camas hospitalarias

Respuesta B. La inmigración de personas sanas y en edad fértil (fenómeno que ha ocurrido en Chile en la última década), produce aumento de la tasa de natalidad, por lo que es necesario destinar mayores recursos a la atención materno infantil. La población usuaria sí aumenta, por lo que muchas veces sí es necesario aumentar la capacidad de atención (ej. personal o camas), pero, al ser sanas, suele ser menor este impacto. El saneamiento básico es importante en las pobaciónes con pirámides de poblacionales...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 124

Un país presenta la siguiente pirámide poblacional: ¿En qué tipo de medidas se deben focalizar las intervenciones de salud pública?

A Prevenir y tratar oportunamente el cáncer
B Prevención del consumo de drogas, cigarrillo y alcohol
C Planificación familiar, prevención de la desnutrición, saneamiento básico y vacunación
D Fomentar la actividad física y prevenir el sedentarismo y la obesidad
E Detección y tratamiento oportuno de enfermedades crónicas no transmisibles

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Planificación familiar, prevención de la desnutrición, saneamiento básico y vacunación).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 153

¿Cuál de los siguientes indicadores es una variable de la demografía dinámica?

A Tasa de fecundidad
B Índice de población urbana / rural
C Tasa de masculinidad
D Distribución etárea
E Tasa de mortalidad infantil

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Tasa de fecundidad).

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 1

¿Cuál corresponde a un indicador de demografía dinámica?

A Tasa de mortalidad infantil
B Tasa de prevalencia de diabetes
C Índice de masa corporal poblacional
D Tasa de alfabetismo
E Porcentaje de cobertura vacunal

Respuesta A. Diagnóstico: Tasa de mortalidad infantil (opción A). Tasa de mortalidad infantil.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 7

Se tiene una población con pirámide poblacional de base ancha y vértice angosto. ¿En qué tipo de medidas debe enfocarse la salud pública?

A Manejo de enfermedades crónicas y oncológicas
B Planificación familiar, saneamiento básico y vacunación
C Rehabilitación y cuidados paliativos
D Prevención cardiovascular en adultos mayores
E Tamizaje de cáncer en adultos

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Planificación familiar, saneamiento básico y vacunación). Planificación familiar, saneamiento básico y vacunación.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 4

Una población presenta la siguiente pirámide poblacional: ¿En qué tipo de medidas deben enfocarse sus políticas de salud pública?

A Prevención y manejo de patologías crónicas no transmisibles
B Prevención y tratamiento de patologías de salud mental
C Saneamiento básico, planificación familiar y vacunación
D Prevención de tabaquismo, alcoholismo y consumo de drogas
E Promoción de actividad física y alimentación saludable

Respuesta C. Es una pirámide joven, por lo que debe enfocarse en salud maternoinfantil, nutrición y control de patologías infecciosas. Todas las demás opciones son importantes en las pirámides de transición y envejecidas, en especial el manejo y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).

▶ VER CLASE 7.01.3.008 Diagnóstico de situación de salud:

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.5 · Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico de situación de salud (ASIS): caracteriza el perfil epidemiológico, sociodemográfico y de determinantes sociales de la población de un territorio (p. ej. la inscrita en un CESFAM).
- Debe ser participativo: combina datos cuantitativos (demografía, morbimortalidad, factores de riesgo, recursos) con la percepción de la comunidad (junta de vecinos, consejos locales).
- Culmina en la priorización de problemas y la programación de acciones, y se actualiza periódicamente.
- Es el insumo del plan de salud comunal y de la planificación del equipo de cabecera.
- No confundir con ecomapa/genograma/APGAR (instrumentos de familia) ni con el estudio de brote (evento puntual).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

El equipo de un CESFAM urbano, con 32.000 inscritos, necesita planificar sus actividades del próximo año. Para ello quiere caracterizar el perfil epidemiológico, sociodemográfico y de determinantes sociales de toda la población de su territorio, usando censos, estadísticas vitales y registros del establecimiento, e incorporando la opinión de la comunidad. **¿Cómo se denomina este proceso?**

A Diagnóstico o análisis de situación de salud
B Estudio de brote
C Ecomapa comunitario
D Vigilancia epidemiológica centinela
E Auditoría clínica

Respuesta A. El diagnóstico o análisis de situación de salud (ASIS) caracteriza la salud de una población de un territorio y sus determinantes, con datos objetivos y participación comunitaria, para priorizar problemas y planificar. El ecomapa evalúa a una familia, no a una comunidad, y el estudio de brote investiga un evento puntual.

▶ VER CLASE 7.01.3.009 Indicadores de nivel de salud: cálculo e interpretación

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.7 · Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

QUÉ HAY QUE SABER

- Prevalencia = casos existentes / población en un momento; incidencia acumulada = casos nuevos / población inicialmente sana en un período; densidad de incidencia = casos nuevos / tiempo-persona.
- Mortalidad infantil = defunciones de menores de 1 año / nacidos vivos × 1.000 (en Chile ~6-7 por mil); neonatal <28 días, postneonatal 28 días a 11 meses. Ejemplo: 16 muertes y 2.000 nacidos vivos = 8 por mil.
- Razón de mortalidad materna = muertes durante el embarazo o hasta 42 días postparto por causas obstétricas / nacidos vivos × 100.000; el denominador son nacidos vivos.
- Letalidad = fallecidos por la enfermedad / casos de la enfermedad (gravedad); mortalidad específica = fallecidos por la causa / población total.
- Chile: la mayor parte de la mortalidad infantil es neonatal (prematurez, malformaciones, afecciones perinatales). Endemia = presencia habitual y estable; epidemia = exceso sobre lo esperado.

PREGUNTAS · 15

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En una comuna, durante un año, hubo 2.000 nacidos vivos y 16 defunciones de menores de 1 año. De estas, 10 ocurrieron en menores de 28 días. **¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil de la comuna?**

A 0,8 por 1.000 nacidos vivos

B 5 por 1.000 nacidos vivos

C 3 por 1.000 nacidos vivos

D 8 por 100.000 nacidos vivos

E 8 por 1.000 nacidos vivos

Respuesta E. Tasa de mortalidad infantil = defunciones de menores de 1 año / nacidos vivos del mismo período × 1.000 = 16/2.000 × 1.000 = 8 por mil. La neonatal (menores de 28 días) sería 10/2.000 × 1.000 = 5 por mil, y la postneonatal 6/2.000 × 1.000 = 3 por mil.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 2

¿Cuál es el mejor indicador para medir la efectividad de la campaña de vacunación contra la influenza?

A La tasa de mortalidad por influenza

B La tasa de letalidad de la influenza

C La tasa de incidencia de influenza

D La tasa de prevalencia de influenza

E La tasa de cobertura de vacunación contra la influenza

Respuesta C. Las vacunas intentan disminuir la incidencia de las patologías infecciosas y esa es la forma en que se mide su efectividad. Sin embargo, hay algunas vacunas que solo logran disminuir los casos graves (ej. rotavirus y recientemente Covid-19 en contra de las variantes del virus).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 20

¿A qué indicador corresponde la siguiente ecuación? (Muertes en menores de 28 días / nacidos vivos) x 1.000

A Tasa de mortalidad infantil

B Tasa de mortalidad perinatal

C Tasa de mortalidad neonatal

D Tasa de mortalidad neonatal precoz

E Tasa de mortalidad postneonatal

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Tasa de mortalidad perinatal).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 122

¿Cuál de los siguientes indicadores es de elección para evaluar la efectividad de una campaña de vacunación contra la influenza?

A Mortalidad mensual por influenza

B Tasa de cobertura de vacunación

C Incidencia semanal por influenza

D Prevalencia de influenza

E Letalidad mensual de la influenza

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Tasa de cobertura de vacunación). La influenza es una de las infecciones respiratorias altas más importantes debido a la intensidad de sus síntomas y su potencial de complicarse con neumonía viral o sobreinfección bacteriana.

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 2

¿Cuál es el mejor indicador para evaluar la efectividad de una campaña de vacunación contra la influenza?

A Tasa de mortalidad por influenza
B Cobertura vacunal alcanzada
C Tasa de incidencia semanal
D Número de hospitalizaciones evitadas
E Porcentaje de población inmunizada

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Tasa de incidencia semanal). Tasa de incidencia semanal. La influenza es una de las infecciones respiratorias altas más importantes debido a la intensidad de sus síntomas y su potencial de complicarse con neumonía viral o sobreinfección bacteriana.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 3

El indicador de letalidad de la influenza corresponde a lo siguiente:

A Casos de influenza / población general
B Casos de influenza / muertes influenza
C Casos de influenza / población expuesta
D Muertes por influenza / Casos de influenza
E Muertes por influenza / población general

Respuesta D. La letalidad son las muertes/casos, es decir, la probabilidad de morirse si es que se enferma. La incidencia son casos/población. La mortalidad es muertes/población. El ataque es la incidencia durante un brote, tomando en cuenta solo la población expuesta al riesgo: muestra muy claramente la trasmisibilidad. Population (in millions>

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 51

Mueren 7 niños menores de 1 año por cada 1000 RNV. Cómo se llama el parámetro: a. Tasa de mortalidad infantil

B Tasa de mortalidad Neonatal
C Mortalidad neonatal tardía
D Mortalidad
E Letalidad
E Control sano habitual

Respuesta A. La alternativa correcta es la A ().

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 3

¿A qué corresponde el siguiente indicador: "Muertes antes de los 28 días / Total de nacidos vivos"?

A Tasa de mortalidad perinatal
B Tasa de mortalidad neonatal
C Tasa de mortalidad infantil
D Tasa de mortalidad posneonatal
E Índice de mortalidad materna

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Tasa de mortalidad neonatal). Tasa de mortalidad neonatal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 100

¿Cuál es el indicador que más se utiliza para reflejar el nivel de desarrollo de los países?

A Tasa de morbilidad general
B Tasa de mortalidad general
C Tasa de fecundidad
D Tasa de natalidad
E Tasa de mortalidad infantil

Respuesta E. La mortalidad infantil refleja muy bien el desarrollo de los países, junto a la expectativa de vida.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 137

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al indicador de letalidad por influenza?

A Número de casos de influenza / Número de fallecidos por influenza
B Número de fallecidos por influenza / Población general
C Número de casos de influenza / Población general
D Número de fallecidos por influenza / Número de casos de influenza
E Número de casos de influenza / Población expuesta

Respuesta D. Letalidad: La letalidad se define como la probabilidad de morir si se contrae una enfermedad. Se calcula dividiendo el número de muertes causadas por la enfermedad entre el total de casos de esa enfermedad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 119

Durante el año 2012 en Chile se presentaron 60 casos de meningitis causadas por la Neisseria Meningitidis serotipo W135, de los cuales 20 fallecieron por causa atribuible a esta enfermedad. Por lo tanto la letalidad de la N.Meningitidis serotipo W135 durante el 2013 fue:

A 25%
B 66%
C 50%
D 33%
E 75%

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (33%). 20/60 = 0,33 = 33%. Esta clase revisa el diagnóstico y manejo de la meningitis bacteriana, viral y tuberculosa.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 14

Tras analizar una tabla que compara la tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad proporcional para distintas patologías entre un periodo inicial y uno tardío: ¿Qué conclusión es posible obtener?

A La variación en la mortalidad proporcional se explica por las variaciones en la tasa de mortalidad de dicha enfermedad
B La tasa de mortalidad por cáncer y por otras causas se mantuvo constante en el 2empo
C El aumento en la tasa de mortalidad por patología cardiovascular se debe al envejecimiento de la población
D La disminución de la proporción de pacientes que mueren por cáncer y otras causas se explica por la disminución de la mortalidad por dichas causas
E La tasa de mortalidad general se man2ene estable

Respuesta B. Aunque al inicio parece difícil, es una pregunta bastante sencilla. La mortalidad por patología cardiovascular sube de 60/1000 a 150/1000. En cambio la mortalidad por cáncer y por otras causas se mantienen constantes en 30/1000 cada una (por eso es correcta la B y falsa la D). Con esto, aumenta la mortalidad general de 120/1000 a 210/1000 (por tanto, es falsa la E) y cambian las mortalidades proporcionales, subiendo el porcentaje de muertes por patología cardiovascular y disminuyendo las por...

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 67

La tasa de natalidad de un país se calcula como el número de nacidos vivos en un año dividido por la población total a mediados de año, multiplicado por 1.000. ¿Cuál es el denominador correcto de este indicador?

A Población total a mediados del año
B Número de mujeres en edad fértil
C Número de embarazos totales
D Población mayor de 15 años
E Total de defunciones del año

Respuesta A. Tasa bruta de natalidad = (nacidos vivos en el año / población total a mitad del año) × 1.000. El denominador es la población total (no solo mujeres fértiles, que corresponde a la tasa de fecundidad).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 67

¿Cuál de los siguientes parámetros es más adecuado para determinar la gravedad de una enfermedad?

A Años de vida saludable perdidos
B Tasa de mortalidad
C Tasa de letalidad
D Tasa de incidencia
E Tasa de ataque

Respuesta A. , C?. La letalidad es un indicador clásico de gravedad, pero los años de vida saludables perdidos también lo son, e incluso es mejor, cuando se trata de enfermedades graves, pero que no causan la muerte, sino que dejan secuelas y causan invalidez. Yo marqué C.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 80

¿A qué indicador corresponde la siguiente afirmación "De 100 pacientes tuberculosos, 13 fallecen"?

A Valor absoluto
B Razón
C Frecuencia relativa
D Índice
E Tasa

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (Tasa). Es la tasa de letalidad (probabilidad de fallecer si se enferma).

▶ VER CLASE `7.01.3.010` **Etapas del diagnóstico de situación de salud**

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.5 · Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- Secuencia del diagnóstico de situación de salud participativo: reunir datos objetivos y percepción comunitaria, describir el perfil de salud, priorizar los problemas y definir estrategias de intervención con la comunidad.
- Fase de recolección: censos, estadísticas vitales, REM del CESFAM, registros clínicos y talleres participativos.
- Priorización con criterios de magnitud, trascendencia, vulnerabilidad (existencia de intervención eficaz) y factibilidad; también método de Hanlon.
- Última fase: plan de acción intersectorial y monitoreo; los datos y la prevalencia son etapas iniciales, no el cierre.
- No se prioriza antes de escuchar a la comunidad ni solo por la prevalencia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 136

Un CESFAM realiza un diagnóstico de salud participativo de su comunidad, en conjunto con la junta de vecinos y el consejo de desarrollo local. **¿Cuál es la última fase del diagnóstico de salud participativo?**

A La comprobación de los problemas de salud referidos por la comunidad

B La determinación de estadísticas y datos objetivos y completos

C La determinación de la prevalencia de las patologías más importantes de la comunidad

D La definición de estrategias de intervención priorizadas

E La realización de estudios experimentales

Respuesta D. El diagnóstico participativo parte reuniendo datos objetivos y la percepción de la comunidad, luego prioriza los problemas, y termina definiendo estrategias de intervención priorizadas en conjunto con la comunidad. Los datos y la prevalencia son etapas iniciales, no el cierre.

▶ VER CLASE 7.01.3.011 Fuentes de información para el diagnóstico

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.13 · Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

QUÉ HAY QUE SABER

- Fuentes de información en salud: estadísticas vitales (certificado de defunción y nacimiento, Registro Civil, DEIS-MINSAL, INE), notificación de enfermedades, REM, ficha clínica, egresos hospitalarios.
- Encuestas: Encuesta Nacional de Salud (prevalencias y factores de riesgo), CASEN (datos socioeconómicos) y Censo (datos poblacionales).
- La fuente primaria de las estadísticas de mortalidad es el certificado médico de defunción, por lo que el correcto llenado por el médico es clave.
- Fuentes primarias (recolectadas para el estudio) vs secundarias (registros existentes); considerar calidad, cobertura y subregistro.
- El médico general genera información con cada ficha, certificado y notificación: de su calidad depende el diagnóstico de salud.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un equipo de salud pública quiere conocer las principales causas de muerte de la región en los últimos 5 años para su diagnóstico de situación de salud. **¿Cuál es la fuente primaria de las estadísticas oficiales de mortalidad en Chile?**

A El certificado médico de defunción

B La Encuesta Nacional de Salud

C El Censo de población

D Las fichas clínicas hospitalarias

E La encuesta CASEN

Respuesta A. Las estadísticas de mortalidad se construyen a partir del certificado médico de defunción, inscrito en el Registro Civil y procesado por el DEIS del Ministerio de Salud y el INE. La Encuesta Nacional de Salud entrega prevalencias de enfermedades y factores de riesgo; el Censo, datos poblacionales; y la CASEN, datos socioeconómicos.

▶ VER CLASE 7.01.3.012 Ejecución de un diagnóstico

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.5 · Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- Ejecución de un diagnóstico de salud en el CESFAM: delimitar el territorio y población a cargo, recolectar datos, describir según persona, lugar y tiempo, y analizar determinantes.
- Característica esencial: debe ser participativo, incorporando a la comunidad (junta de vecinos, consejo de desarrollo local) además de los datos cuantitativos.
- Luego se priorizan problemas (magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, factibilidad) y se programan acciones con responsables, metas e indicadores.
- Se actualiza periódicamente y alimenta el plan de salud comunal.
- Herramienta epidemiológica adecuada para identificar qué grupos, sectores y épocas concentran un problema: epidemiología descriptiva.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

El equipo de un CESFAM debe realizar el diagnóstico de situación de salud de su población a cargo, conforme al Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria. **¿Qué característica es esencial en la ejecución de este diagnóstico?**

A Limitarse a las enfermedades de notificación obligatoria

B Basarse exclusivamente en los egresos hospitalarios

C Ser elaborado únicamente por la dirección del establecimiento

D Incorporar la participación de la comunidad e integrar información cuantitativa y cualitativa

E Realizarse una sola vez, al inaugurar el centro

Respuesta D. El diagnóstico de situación de salud debe ser participativo: combina datos cuantitativos (demográficos, morbimortalidad, factores de riesgo, recursos) con la percepción de la comunidad sobre sus problemas. Culmina en la priorización de problemas y la programación de acciones, y se actualiza periódicamente.

▶ VER CLASE 7.01.3.013 Concepto y campo de la epidemiología

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.6 · Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

QUÉ HAY QUE SABER

- Epidemiología: estudio de la frecuencia, distribución y determinantes de los estados o eventos de salud en poblaciones, y aplicación de ese conocimiento al control de los problemas.
- Descriptiva: caracteriza según persona, lugar y tiempo y genera hipótesis; analítica: contrasta hipótesis y establece asociación y causalidad (cohortes, casos y controles, experimentos).
- Campo amplio: infecciones, enfermedades crónicas, lesiones, factores de riesgo, evaluación de servicios y programas; no se limita a las enfermedades transmisibles.
- La bioestadística es una herramienta de la epidemiología, no la rama que contrasta hipótesis.
- Clave de examen: la rama que obtiene información mediante el contraste de hipótesis es la epidemiología analítica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En la primera clase de epidemiología se pide a los alumnos elegir la definición más completa de la disciplina. **¿Cuál es la mejor definición de epidemiología?**

A Estudio exclusivo de las epidemias de enfermedades infecciosas

B Estudio de la distribución y de los determinantes de los estados de salud en poblaciones, y su aplicación al control de los problemas de salud

C Ciencia que trata a los pacientes individuales según la evidencia

D Rama de la estadística que estudia los ensayos clínicos

E Disciplina que administra los recursos de los servicios de salud

Respuesta B. La epidemiología estudia la frecuencia y distribución (epidemiología descriptiva) y los determinantes (epidemiología analítica) de los eventos de salud en poblaciones, y aplica ese conocimiento al control de los problemas. No se limita a las infecciones: incluye enfermedades crónicas, lesiones, factores de riesgo y evaluación de servicios.

▶ VER CLASE 7.01.3.014 Epidemiología descriptiva

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.7 · Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

QUÉ HAY QUE SABER

- Epidemiología descriptiva: responde quién (persona: edad, sexo, ocupación), dónde (lugar) y cuándo (tiempo: tendencias, estacionalidad, conglomerados).
- Cuantifica la magnitud del problema, identifica grupos de riesgo y genera hipótesis; precede a la etapa analítica.
- Medidas: prevalencia, incidencia, mortalidad, letalidad; el estudio de prevalencia (transversal) mide exposición y enfermedad en un mismo momento.
- Términos: endemia (presencia habitual y estable con variaciones estacionales), epidemia (exceso sobre lo esperado), pandemia (extensión mundial), brote (casos relacionados en tiempo corto).
- Las medidas de asociación corresponden a la epidemiología analítica, no a la descriptiva.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 152

¿Cuál de las siguientes patologías no es autóctona de Chile? **Elige la alternativa correcta.**

A Síndrome pulmonar por hantavirus

B Leptospirosis

C Influenza

D Dengue

E Malaria

Respuesta E. En Chile no hay malaria autóctona: todos los casos son importados. El dengue sí tiene transmisión local en Isla de Pascua, donde existe el vector.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 98

En una región del país, una enfermedad infecciosa presenta año tras año un número de casos similar, con aumentos esperables en invierno. **¿Qué significa que una enfermedad sea endémica?**

A Que mantiene una frecuencia relativamente estable en la zona, con sus variaciones estacionales

B Que presenta muchos más casos que los habituales para la zona geográfica

C Que se extiende a todos los lugares del planeta

D Que presenta varios casos, relacionados entre sí, en un corto período de tiempo

E Que presenta casos escasos, sin poder identificar un patrón

Respuesta A. Endemia es la presencia habitual de una enfermedad en una zona, con frecuencia relativamente estable y sus variaciones estacionales. Epidemia es un exceso de casos sobre lo esperado, pandemia es una epidemia de extensión mundial y brote son casos relacionados en un tiempo corto.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 129

Si se quiere hacer un estudio donde se describe en un grupo de niños cuales son los FR, edad, enfermedades?, cómo se llamaría:

A Analitico

B Ecológico

C Descriptivo

D Control sano habitual

E Derivar a especialista

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Descriptivo).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 47

Si se mejorara el tratamiento de una enfermedad crónica, y se mantiene la incidencia, ¿qué pasará con la prevalencia?

A Aumenta

B No se modifica

C Disminuye

D No se puede determinar

E Depende de la enfermedad

Respuesta A. Si la enfermedad crónica es incurable, al mejorar el tratamiento, se muere menos gente y aumenta la prevalencia. Si fuera curable, sí disminuiría la prevalencia, ya que se curarían. Sin embargo, la D y la E hacen pensar que la respuesta que se quería como correcta era la A.

▶ VER CLASE 7.01.3.015 Usos de la epidemiología en el control de enfermedades

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.4 · Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

QUÉ HAY QUE SABER

- Usos de la epidemiología en el control de enfermedades: vigilancia, investigación de brotes, identificación de factores de riesgo y evaluación de intervenciones (vacunas, programas).
- Control de infecciosas: vacunación masiva es la estrategia de mayor impacto sobre la mortalidad por infecciones respiratorias (protege al vacunado y genera inmunidad de rebaño); cuarentena y aislamiento son complementarias y transitorias.
- Éxito de una campaña de vacunación (efectividad): disminución de la incidencia de la enfermedad; la cobertura es solo un indicador de proceso.
- La profilaxis antibiótica no sirve contra virus.
- Ejemplo: Programa Nacional de Inmunizaciones, con cobertura alta sostenida para mantener inmunidad de rebaño.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 69

Se desea evaluar los resultados de una campaña de vacunación en la población. **¿Cuál es el mejor indicador para determinar el éxito de una campaña de vacunación?**

A Tasa de incidencia

B Tasa de prevalencia

C Tasa de hospitalizaciones

D Tasa de mortalidad

E Tasa de cobertura de vacunación

Respuesta A. El objetivo de una vacuna es prevenir casos nuevos, por lo que su éxito (efectividad) se mide por la disminución de la incidencia de la enfermedad. La cobertura es un indicador de proceso: dice cuántos se vacunaron, no si se evitó la enfermedad. La mortalidad depende además de la letalidad y del tratamiento.

▶ VER CLASE 7.01.3.016 Vigilancia epidemiológica y estudio de brotes

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.4 · Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

QUÉ HAY QUE SABER

- Vigilancia epidemiológica: recolección, análisis e interpretación sistemática de datos para actuar; activa (notificación obligatoria caso a caso), centinela (muestreo en centros seleccionados) y pasiva (estadísticas generales).
- Vigilancia centinela: enfermedades frecuentes y poco graves (infecciones respiratorias altas, diarreas, influenza, varicela); no es notificación caso a caso.
- Notificación obligatoria (DS N°7) en Epivigila: inmediata ante sospecha, sin esperar laboratorio (meningococo, hantavirus, sarampión, rubéola, rabia, cólera, botulismo, brotes de ETA); diaria dentro de 24 h (TBC, sífilis, gonorrea, VIH, hepatitis virales, coqueluche, Chagas, tétanos).
- Estudio de brote: confirmar el diagnóstico y la existencia del brote, definir caso, buscar casos, describir por persona-lugar-tiempo, plantear hipótesis (casos y controles), aplicar control y comunicar.
- Brote de ETA: ≥2 personas con el mismo cuadro tras un alimento común; notificar a la SEREMI, inspección sanitaria, decomiso, coprocultivos, tasa de ataque y riesgo relativo por alimento.

PREGUNTAS · 10

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 44

¿Por qué la meningococcemia es una enfermedad de notificación inmediata? **Seleccione la alternativa correcta:**

A Para aislar a los contactos
B Para vacunar a la familia
C Para identificar y manejar a los contactos
D Para detectar casos secundarios
E Por la gravedad de la enfermedad

Respuesta C. La notificación inmediata permite identificar a los contactos y darles quimioprofilaxis (rifampicina, ciprofloxacino o ceftriaxona en la embarazada) a tiempo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 107

Respecto al DIEP (Departamento de Infecciones y Epidemiología del Paciente) en hospitales chilenos, ¿cuál es su función principal? **Seleccione la alternativa correcta:**

A Vigilar, prevenir y controlar las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS)
B Gestionar los recursos humanos del hospital
C Supervisar la farmacia hospitalaria
D Coordinar las licencias médicas
E Auditar los estados financieros del hospital

Respuesta A. El DIEP (o comité de IAAS) de los hospitales chilenos tiene como función primordial la vigilancia epidemiológica, la prevención y el control de las infecciones asociadas a la atención de salud.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 60

Usted atiende a 5 pacientes que consultan por vómitos y diarrea de inicio agudo en el mismo servicio de urgencia. Todos ellos son compañeros de trabajo, que almuerzan en el mismo comedor, por lo que se sospecha una intoxicación alimentaria. Además del manejo específico de los síntomas y patología de cada uno de ellos, la medida más adecuada es: **Seleccione la alternativa correcta:**

A Notificar al encargado de epidemiología del Hospital
B Realizar un interrogatorio detallado a cada uno de los pacientes, para identificar el agente causal
C Notificar a la Seremi de Salud
D Notificar al Director del Hospital
E Notificar a la Superintendencia de Salud

Respuesta C. La sospecha de un brote de intoxicación alimentaria es de notificación obligatoria, y en Chile la notificación se hace a la Seremi de Salud ante la sola sospecha, para que la autoridad sanitaria tome medidas y contenga el brote.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 98

¿Mediante qué estrategia epidemiológica se debe enfrentar la sospecha de un brote de intoxicación alimentaria para su adecuada identificación y control? **Seleccione la alternativa correcta:**

A Vigilancia activa
B Estudio experimental
C Vigilancia centinela
D Estudio analítico
E Vigilancia pasiva

Respuesta A. Las intoxicaciones alimentarias se manejan con vigilancia activa, es decir, con notificación obligatoria ante la sola sospecha. La vigilancia centinela se usa en infecciones frecuentes y poco graves (solo informan algunos centros), y la pasiva en infecciones leves o poco transmisibles.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 44

¿Qué tipo de vigilancia se utiliza en patologías como las infecciones respiratorias altas, las diarreas y las enfermedades de transmisión sexual? **¿Cuál es el tipo de vigilancia correcto?**

A Vigilancia activa
B Vigilancia centinela
C Vigilancia de notificación obligatoria
D Estudios de prevalencia
E Estudios experimentales

Respuesta B. La vigilancia centinela se usa en enfermedades frecuentes y de menor gravedad, como infecciones respiratorias altas, diarreas y varicela, con muestreo en centros de salud determinados; excepto sífilis y gonorrea, que sí son de notificación obligatoria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 106

El médico de un CESFAM detecta un brote de hepatitis A en su sector. ¿A qué autoridad sanitaria debe notificar de forma inmediata?

A SEREMI de Salud
B Ministerio de Salud directamente
C FONASA
D ISP
E Municipalidad

Respuesta A. En Chile, las enfermedades de notificación obligatoria inmediata (ENNOI) como brotes de hepatitis A se notifican al SEREMI de Salud de la región correspondiente dentro de las 24 horas.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 142

En la vigilancia de las enfermedades transmisibles, ¿cuál es el parámetro que se utiliza para definir si la notificación de los casos de dicha enfermedad es de tipo diaria o inmediata?

A Periodo de incubación
B Oportunidad de control y prevención
C Letalidad y prevalencia
D Número de casos
E Disponibilidad de vacuna

Respuesta C. La velocidad con la que se notifica considera la gravedad de la enfermedad (letalidad) y la frecuencia de casos (más que prevalencia es la incidencia, pero es la única respuesta aceptable). En general solo se notifican enfermedades graves y que son infrecuentes y mientras más graves, se notifican más rápido.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 24

¿Cuál es la mejor estrategia de vigilancia para una enfermedad infectocontagiosa, que se transmite a través de la contaminación de acuíferos?

A Vigilancia activa
B Vigilancia pasiva
C Vigilancia estacional
D Encuestas
E Centros centinelas

Respuesta A. Pregunta muy rara. La vigilancia activa de los acuíferos (aguas superficiales y aguas subterráneas) es lo más razonable, con toma de muestras y análisis periódicos de las aguas en cuestión, más análisis directo, en caso de reportarse casos sospechosos (por eso marcamos la vigilancia activa como respuesta). Pero la verdad es que, en Chile, las diarreas (incluyendo el cólera, por ejemplo), se vigilan mediante centros centinelas (hospitales o clínicas determinadas, que deben estudiar las...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 41

La notificación obligatoria de ciertas enfermedades transmisibles tiene como objetivo:

A Evaluar la efectividad de las vacunas administradas a la población
B Identificar las enfermedades infecciosas más importantes en la población
C Determinar la propagación de las enfermedades más letales
D Identificar y controlar situaciones epidémicas
E Reunir información estadística completa y confiable, para determinar las políticas de salud

Respuesta D. La vigilancia activa (notificación obligatoria) busca identificar los brotes de manera rápida, para poder contenerlo, haciendo un adecuado manejo de los casos (aislamiento y tratamineto) y de los contactos (profilaxis y observación).

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 5

La notificación obligatoria de algunas enfermedades transmisibles tiene como objetivo:

A Evaluar la efectividad de las vacunas administradas a la población

B Identificar las principales enfermedades transmisibles en la población

C Determinar la propagación de las enfermedades infecciosas más importantes

D Ayudar a identificar y controlar situaciones epidémicas

E Reunir información estadística completa y confiable, para determinar las políticas de salud

Respuesta D. La notificación obligatoria es una medida de vigilancia activa, que busca conocer rápidamente sobre la presencia de casos de una enfermedad infecciosa, de modo de identificar y manejar a los contactos, tanto en brotes como en epidemias (y pandemias). La efectividad de vacunas se mide con ensayos clínicos o de campo. Las demás opciones se pueden lograr con un buen registro epidemiológico, sin necesidad de una notificación rápida.

▶ VER CLASE 7.01.3.017 Usos de la epidemiología en el diagnóstico de situación de salud

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.5 · Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- La epidemiología describe la magnitud y distribución de los problemas de salud según persona, lugar y tiempo, e identifica los grupos de riesgo para priorizar y focalizar recursos en el diagnóstico de situación.
- Ejemplo: para saber qué edades, sectores y épocas concentran la obesidad infantil se usa la epidemiología descriptiva; los diseños analíticos buscan causas.
- Insumos: estadísticas vitales, morbilidad, Encuesta Nacional de Salud, REM y factores de riesgo.
- Indicadores: incidencia, prevalencia, mortalidad específica, años de vida potencialmente perdidos.
- Resultado: priorización con magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un equipo comunal, en su diagnóstico de situación de salud, quiere identificar qué grupos de edad, sectores de la comuna y períodos del año concentran la mayor obesidad infantil, para orientar sus recursos. **¿Qué herramienta epidemiológica es la más adecuada para este fin?**

A Análisis de costo-efectividad

B Ensayo clínico aleatorizado

C Epidemiología descriptiva, según persona, lugar y tiempo

D Auditoría clínica

E Estudio de cohortes a 20 años

Respuesta C. En el diagnóstico de situación, la epidemiología describe la magnitud y distribución de los problemas de salud según persona, lugar y tiempo, identificando grupos de riesgo para priorizar y focalizar intervenciones. Los diseños analíticos o experimentales buscan causas o evalúan intervenciones, lo que no es el objetivo aquí.

▶ VER CLASE 7.01.3.018 Epidemiología analítica

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.6 · Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

QUÉ HAY QUE SABER

- Epidemiología analítica: contrasta hipótesis comparando grupos para establecer asociación y causalidad, con estudios de cohorte, casos y controles y experimentales.
- Pregunta clave del diseño: ¿el investigador asignó la exposición? Sí = experimental; no = observacional. Luego, ¿cómo se seleccionó a los sujetos? Por exposición = cohortes; por enfermedad = casos y controles.
- Medidas: riesgo relativo en cohortes y ensayos; odds ratio en casos y controles.
- Ambigüedad temporal en estudios transversales: no establecen causalidad.
- Se complementa con la evaluación de sesgos, confusión y criterios de causalidad de Bradford Hill.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 99

La salud pública dispone de distintas ramas para obtener y analizar información sobre los problemas de salud. **¿Qué rama de la Salud Pública se preocupa de obtener información a través del contraste de hipótesis?**

A Epidemiología descriptiva

B Bioestadística

C Prevención de salud

D Epidemiología analítica

E Vigilancia epidemiológica

Respuesta D. La epidemiología descriptiva caracteriza los problemas según persona, lugar y tiempo y genera hipótesis; la epidemiología analítica las pone a prueba, comparando grupos para establecer asociación y causalidad, mediante estudios de cohorte, casos y controles y experimentales. La bioestadística es una herramienta, no la rama que plantea el contraste.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2018 · PREGUNTA 21

Se realiza un estudio que muestra que en la comuna A, el consumo de drogas es de un 40%, mientras que en la comuna B, es de 10%. El diseño de estudio más adecuado, para determinar las causas de estas diferencias, es:

A Ecológico
B Descriptivo
C Analítico
D De prevalencia
E De incidencia Respuesta: Las relaciones de causalidad, se estudian con la epidemiología analític

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Analítico).

▶ VER CLASE 7.01.3.019 Medidas de asociación e impacto

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.7 · Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

QUÉ HAY QUE SABER

- Tabla 2x2: a expuestos enfermos, b expuestos sanos, c no expuestos enfermos, d no expuestos sanos. Riesgo relativo = [a/(a+b)] / [c/(c+d)] en cohortes y ensayos; odds ratio = (a×d)/(b×c) en casos y controles.
- RR u OR = 1 sin asociación; >1 factor de riesgo; <1 factor protector. Es significativo solo si el IC 95% no incluye 1 (para reducción absoluta de riesgo, el valor nulo es 0).
- Impacto: reducción absoluta del riesgo = riesgo control – riesgo tratamiento; reducción relativa = RAR / riesgo control; NNT = 1/RAR, redondeado hacia arriba (12% vs 8% = RAR 4% = NNT 25).
- Riesgo atribuible y riesgo atribuible porcentual son medidas de impacto, no de cuántas veces más riesgo.
- Trampa: un OR de 1,3 con IC 0,86-2,1 cruza el 1, la asociación no es significativa; un OR no es 'un 30% más de riesgo' real.

PREGUNTAS · 7

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 71

Se busca la asociación entre distintos parámetros con el cáncer de tiroides, en un estudio de caso control, con el Odds Ratio (OR) más un intervalo de confianza (IC) al 95%: antecedentes familiares OR 1,88 IC 0,56 a 4,01; edad OR 2,6 IC 0,95 a 3,17; sexo masculino OR 0,56 IC 0,33 a 0,87; exposición a radiación OR 1,52 IC 0,91 a 2,01; tiroiditis de Hashimoto OR 4,6 IC 0,7 a 6,2. **¿Qué factor es más importante en esta asociación?**

A Antecedentes familiares: OR 1,88; IC 0,56 a 4,01
B Edad: OR 2,6; IC 0,95 a 3,17
C Sexo masculino: OR 0,56; IC 0,33 a 0,87
D Exposición a radiación: OR 1,52; IC 0,91 a 2,01
E Tiroiditis de Hashimoto: OR 4,6; IC 0,7 a 6,2

Respuesta C. Solo la opción del sexo masculino tiene un intervalo de confianza que no cruza el uno, con ambos límites bajo uno: es la única estadísticamente significativa, y corresponde a un factor protector, ya que su Odds Ratio es menor a uno. Las otras cuatro, aunque tienen Odds Ratio numéricamente más llamativos, tienen intervalos que incluyen el valor nulo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 31

Se busca la medida de asociación más adecuada para establecer cuántas veces aumentan los casos de asma en la población fumadora, en comparación con la población no fumadora. **¿Cuál de las siguientes medidas de asociación es la más adecuada?**

A Riesgo relativo
B Riesgo atribuible
C Razón de prevalencias
D Tasa de incidencia
E Riesgo atribuible porcentual

Respuesta A. El Riesgo Relativo es, por definición, la razón entre la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos: expresa directamente cuántas veces más frecuente es el evento en un grupo respecto al otro. El riesgo atribuible y el riesgo atribuible porcentual son medidas de impacto, no de cuántas veces más riesgo hay.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 35

Un estudio de cohortes busca establecer la asociación entre la exposición a estrógenos y el cáncer de ovario. Luego de analizar los datos, se obtiene que el Odds Ratio es 1,3 con un intervalo de confianza al 95% de 0,86 a 2,1. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con estos resultados?**

A Las mujeres expuestas a estrógeno tienen 1,3 veces más riesgo de presentar cáncer de ovario
B Las mujeres expuestas a estrógeno tienen 30% más de riesgo de presentar cáncer de ovario
C Existe una asociación entre el uso de estrógenos y el desarrollo de cáncer de ovario, pero no es significativa
D Las mujeres que tienen cáncer de ovario estuvieron expuestas a un 30% más de estrógeno
E Se prueba la asociación entre el uso de estrógenos y el desarrollo de cáncer de ovario, pero no es extrapolable

Respuesta C. El Odds Ratio de 1,3 sugiere un aumento del riesgo, pero su intervalo de confianza al 95% va de 0,86 a 2,1 e incluye el valor nulo de 1,0. Eso significa que la asociación observada no alcanza significancia estadística: no se puede descartar que el resultado se deba al azar, aunque el punto estimado sugiera un factor de riesgo.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un ensayo clínico aleatorizado compara un nuevo antiagregante plaquetario frente a aspirina para prevenir accidente cerebrovascular isquémico recurrente a 2 años. La incidencia acumulada de ACV fue de 12% en el grupo aspirina y de 8% en el grupo con el nuevo fármaco. **¿Cuál es el número necesario a tratar con el nuevo fármaco para evitar un accidente cerebrovascular?**

A 25 pacientes
B 8 pacientes
C 12 pacientes
D 33 pacientes
E 4 pacientes

Respuesta A. La reducción absoluta del riesgo es 12% menos 8%, es decir 4 puntos porcentuales (0,04). El número necesario a tratar es 1 dividido en 0,04, es decir 25 pacientes deben tratarse con el nuevo fármaco durante 2 años para evitar un accidente cerebrovascular isquémico adicional.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 103

La medida que mejor estima la diferencia de riesgo entre un grupo expuesto y otro no expuestoa un factor de riesgo en una misma población es:

A Riesgo atribuible
B Odds Ratio
C Riesgo Relativo
D Incidencia acumulada
E Razón de incidencias

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Riesgo atribuible). Es la definición de RA = Ie - Io.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 29

Se realiza un estudio de casos y controles que busca establecer la asociación entre el uso de anticonceptivos orales y cáncer. Luego de analizar los datos se obtiene que el Odds Ratio 1,3 con intervalo de confianza al 95% con valores entre 0,86 y 2,1. Con estos resultados se puede afirmar que:

A Existe una relación positiva entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer
B Existe una relación positiva entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer, pero que no es estadísticamete significativa
C Existe una asociación entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer, pero este resultado no es extrapolable a otras poblaciones
D Las personas que tienen cáncer consumen un 30% más de anticonceptivos orales
E Las personas que usan anticonceptivos orales, tienen 1,3 veces más riesgo de desarrollar cáncer.

Respuesta B. El OR pasa por el 1,0 en su intervalo de confianza al 95%, por lo que no es estadísti- camente significativo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 46

Un estudio investiga la correlación entre el uso de drogas durante el embarazo y las alteraciones cognitivas en los niños. Para ello, se selecciona a un grupo de niños con discapacidad cognitiva y se compara con otro grupo de niños sanos, realizándole una entrevista a la madre, sobre la exposición a distintos factores de riesgo, durante el embarazo. ¿Qué medida de asociación se debe utilizar en este estudio?

A Riesgo relativo
B Riesgo atribuible
C Riesgo atribuible poblacional
D Odds ratio
E Incidencia

Respuesta D. Es un estudio de casos y controles, por lo que se calcula el OR, como medida de asociación. El riesgo relativo también era una medida de asociación (las demás no).

▶ VER CLASE 7.01.3.020 **Diseños de investigación epidemiológica**

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.6 · Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

QUÉ HAY QUE SABER

- Primera pregunta: ¿el investigador asigna la exposición? Sí = experimental (ensayo clínico aleatorizado); no = observacional.
- Observacional con datos agregados de poblaciones (países, comunas) = ecológico; con individuos, ¿selección por exposición (cohortes) o por enfermedad (casos y controles)? Todo medido en un momento = transversal.
- Casos y controles: ideal para enfermedades raras o de larga latencia; mide OR; sesgo de memoria. Cohortes: ideal para exposiciones raras, permite varios desenlaces, mide incidencia y RR; riesgo de pérdidas de seguimiento.
- Ensayo clínico: estándar de oro para eficacia; aleatorización reparte confusores, enmascaramiento (simple, doble, triple ciego) evita sesgos; fases I (20-80 sanos, seguridad), II (100-300 enfermos), III (miles, multicéntrico), IV (poscomercialización).
- Transversal: rápido y barato, estima prevalencia, pero con ambigüedad temporal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un equipo de salud pública quiere estudiar si la exposición ocupacional al plomo se asocia con el desarrollo de insuficiencia renal crónica. Reclutan a 400 trabajadores de fundiciones, sin enfermedad renal al momento del ingreso, clasificados según su nivel de exposición al plomo en el ambiente laboral, y los siguen anualmente durante 12 años, midiendo la función renal. **¿A qué diseño de estudio corresponde esta investigación?**

A Estudio de cohortes prospectivo

B Estudio de casos y controles

C Estudio transversal

D Ensayo clínico aleatorizado

E Estudio ecológico

Respuesta A. Los sujetos se seleccionan sanos al inicio, según su exposición al plomo, y se siguen prospectivamente para registrar la aparición de nuevos casos de insuficiencia renal. Esa estructura, selección por exposición y seguimiento longitudinal, define un estudio de cohortes prospectivo, el diseño de elección para una exposición ocupacional infrecuente.

▶ VER CLASE 7.01.3.021 Estudios de prevalencia

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.6 · Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

QUÉ HAY QUE SABER

- Estudio de prevalencia (transversal): mide exposición y enfermedad en un mismo momento, sin seguimiento; entrega prevalencia (ej. Encuesta Nacional de Salud).
- Ventajas: rápido, barato, útil para planificar recursos y servicios.
- Limitación principal: ambigüedad temporal; no puede saber si la causa precedió al efecto, por lo que no establece causalidad ni calcula incidencia.
- Para incidencia o riesgo relativo se necesita seguir a personas inicialmente sanas (cohortes).
- Sensible al sesgo de supervivencia: sobrerrepresenta a enfermos de larga duración.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

La Encuesta Nacional de Salud mide, en un período breve, la presión arterial de una muestra representativa de la población chilena adulta y pregunta si la persona conoce su diagnóstico de hipertensión. **¿Qué medida de frecuencia entrega directamente este tipo de estudio?**

A Prevalencia

B Incidencia acumulada

C Densidad de incidencia

D Riesgo relativo

E Letalidad

Respuesta A. Un estudio de prevalencia (transversal) mide exposición y enfermedad en un mismo momento, sin seguimiento, por lo que entrega la proporción de personas que tienen la condición: la prevalencia. Para calcular incidencia o riesgo relativo se requiere seguir en el tiempo a personas inicialmente sanas, como en un estudio de cohortes.

▶ VER CLASE 7.01.3.022 Estudios de casos y controles

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.6 · Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

QUÉ HAY QUE SABER

- Casos y controles: se selecciona por la enfermedad (casos) y sanos comparables (controles) y se indaga hacia atrás la exposición; retrospectivo.
- Diseño de elección para enfermedades raras o de larga latencia (p. ej. cáncer): rápido y barato; es el más eficiente ante enfermedades muy infrecuentes.
- Medida de asociación: odds ratio = (a×d)/(b×c); no se calcula incidencia ni RR porque el investigador fija cuántos enfermos y sanos reclutar.
- Sesgos típicos: de memoria (el enfermo recuerda mejor la exposición), del entrevistador y de selección (Berkson si se reclutan solo en hospital).
- Se controla con registros objetivos, ciego del entrevistador y controles de base comunitaria.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 110

Se busca el diseño de estudio más adecuado para estudiar enfermedades muy infrecuentes en la población. **¿Cuál es el diseño de estudio más adecuado para estudiar enfermedades muy infrecuentes?**

A Cohortes prospectivas

B Caso control

C De prevalencia

D Ensayo clínico

E Cohortes retrospectiva

Respuesta B. Casos y controles es el diseño más eficiente frente a enfermedades raras, porque permite reclutar directamente a los pocos enfermos existentes; un estudio de cohortes tendría que seguir a una población enorme durante años para observar un número suficiente de casos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 92

¿Cuál es el mejor tipo de estudio para enfermedades poco prevalentes?

A Serie de casos
B Estudio de cohortes
C Ensayo clínico
D Estudio ecológico
E Estudios de caso-control

Respuesta E. Casos y controels sirven para: poco prevalentes, bajo presupuesto y enfermedades que demoran mucho en aparecer.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 147

Se realiza un estudio donde se desea estudiar los factores de riesgos asociado al lupus, por esto se seleccionan dos grupos, uno de ellos con pacientes diagnosticadas de lupus y el otro de características demográficas similares pero sanos. ¿A qué tipo de estudio corresponde el diseño mencionado anteriormente?

A Cohorte prospectivo
B Prevalencia
C Caso control
D Ensayo clínico controlado
E Estudio ecológico

Respuesta C. Falta decir qué se hace con esos pacientes. Si se les preguntan sus factores de riesgo (si fuman, toman, etc) sería casos y controles. No puede ser cohortes, porque no se va a a ver a futuro qué FR desarrollan (sería ilógico), porque ya están enfermos o sanos.

▶ VER CLASE 7.01.3.023 Estudios de cohortes

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.6 · Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

QUÉ HAY QUE SABER

- Cohortes: se seleccionan sujetos sanos según estén expuestos o no y se siguen en el tiempo para ver quién enferma (prospectivo, o retrospectivo con registros históricos).
- Diseño de elección para exposiciones infrecuentes (p. ej. tóxico laboral); permite evaluar múltiples desenlaces de una misma exposición.
- Mide incidencia y riesgo relativo; la causa precede al efecto, lo que da mayor fuerza causal.
- Desventajas: caro, lento, ineficiente para enfermedades raras; su principal sesgo son las pérdidas de seguimiento.
- Con datos de un solo grupo (65 de 2.000 fumadores con cáncer a 20 años) solo se calcula incidencia acumulada (3,25%); para RR se necesita el grupo no expuesto.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 13

En un estudio de cohortes sobre el tabaco y cáncer de pulmón, luego de 20 años, se determina que 65 de 2.000 pacientes fumadores enfermaron de cáncer. **¿Qué medida es posible calcular con esta información?**

A Incidencia acumulada en los pacientes fumadores
B Prevalencia en los pacientes fumadores
C Riesgo relativo
D Odds ratio
E Tasa de ataque en los pacientes fumadores

Respuesta A. Con datos de un solo grupo (los fumadores) solo se puede calcular la incidencia acumulada en ese grupo: 65 dividido en 2.000. Para calcular Riesgo Relativo u Odds Ratio se necesitaría además el dato de los no fumadores, que aquí no está.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 40

Se realiza un estudio donde se comparan dos grupos de personas mayores de 60 años, uno de ellos corresponde a hipertensos y el otro de características similares pero sin hipertensos, se siguen por 5 años y se evalúa la aparición de infarto agudo al miocardio o accidente cerebrovascular. Este enunciado corresponde a un estudio de:

A Corte transversal
B Caso control
C Estudio clínico randomizado
D Cohorte
E Ensayo de campo

Respuesta D. Diagnóstico: Cohorte (opción D). Se siguen al futuro dos grupos: expuestos y no expuestos a un FR (HTA en este caso).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 49

Se hace estudio de FRCV y alimentación en estudiantes medicina en el año 2000. En el 2022 se reevalúa a los mismos para ver aparición de enfermedades cv. Qué tipo de estudio es: a. Cohortes prospectivo.

B Cohorte retrospectivo

C Caso control

D Transversal

D Hemograma y VHS

E Ecografía

Respuesta A. La alternativa correcta es la A ().

▶ VER CLASE **7.01.3.024** **Estudios experimentales y cuasiexperimentales**

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.6 · Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

QUÉ HAY QUE SABER

- Experimental: el investigador asigna la intervención, que es lo que lo diferencia de los demás diseños; la aleatorización y el ciego son deseables pero no definitorios.
- Ensayo clínico aleatorizado: estándar de oro para causalidad terapéutica; la aleatorización reparte equilibradamente confusores conocidos y desconocidos; el enmascaramiento (simple, doble, triple ciego) evita sesgos de información.
- Fases: I (20-80 voluntarios sanos: seguridad y dosis), II (100-300 pacientes: eficacia preliminar), III (miles, multicéntrico: decide la aprobación), IV (poscomercialización: efectos adversos raros).
- Cuasiexperimental: hay intervención pero sin aleatorización o sin grupo control equivalente.
- Limitación: puede perder validez externa si los criterios de inclusión son muy estrictos; problemas éticos y costo.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 146

Un grupo de investigadores discute qué diseño usar para su próximo estudio y revisa en qué se diferencian los estudios experimentales de los observacionales. **¿Cuál es la característica de los estudios experimentales que los diferencia de los demás tipos de estudios?**

A La selección es aleatorizada

B Siempre utilizan triple ciego

C El investigador controla algunas variables

D El investigador selecciona los grupos de intervención

E Utilizan test de hipótesis

Respuesta C. Lo que define a un estudio experimental es que el investigador asigna la intervención, es decir, controla la variable de exposición. La aleatorización y el enmascaramiento son deseables para reducir sesgos, pero no son obligatorios, y los test de hipótesis se usan también en estudios observacionales analíticos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2013 · PREGUNTA 5

Se desea evaluar la efectividad de un nuevo antihipertensivo de la familia de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, para esto, ¿Qué tipo de estudio escogería?

A Caso control

B Meta-análisis

C Cohorte

D Corte transversal

E Estudio clínico randomizado

Respuesta E. Por ser un fármaco nuevo es imposible tener estudios para hacer un meta-análisis. Así que lo mejor es el ensayo clínico. Eso sí, lo que se mide es eficacia y no efectividad, pero de todos modos es la respuesta más correcta.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 124

Un estudio determina que se deben tratar a 20 pacientes con una intervención, para evitar que uno fallezca. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

A De incidencia

B Casos y controles

C Cohortes anidada

D Ensayo clínico

E De prevalencia

Respuesta D. Se calculó el NNT, que en este caso es de 20. Sin embargo, lo preguntado es qué tipo de estudio es y por tratarse de una "intervención", se asume que es un estudio experimental, es decir, un ensayo clínico.

▶ VER CLASE 7.01.3.025 Concepto de estudios ecológicos

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.6 · Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

QUÉ HAY QUE SABER

- Estudio ecológico: la unidad de análisis son poblaciones (países, comunas), no individuos; correlaciona promedios de exposición con tasas de enfermedad.
- Ejemplo: tasa de infarto por país según consumo de grasas saturadas, sin seguir a ningún individuo.
- Es observacional, pero ecológico es la clasificación más específica.
- Limitación central: falacia ecológica, asumir que la asociación a nivel de grupo se cumple en cada persona.
- Útil para generar hipótesis con datos ya disponibles, de bajo costo.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 65

En un estudio se analiza la tasa de infarto al miocardio en distintos países según el consumo de grasas saturadas, sin seguir a individuos en el tiempo. **¿Qué tipo de diseño epidemiológico corresponde?**

A Estudio ecológico
B Estudio de cohorte
C Estudio de casos y controles
D Ensayo clínico aleatorizado
E Estudio transversal

Respuesta A. La unidad de análisis son países, no individuos: se comparan tasas agregadas de enfermedad entre grupos, sin seguir a ninguna persona. Eso define al estudio ecológico, cuya limitación principal es la falacia ecológica: no se puede inferir la asociación a nivel individual.

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 8

En un estudio se miden los niveles plasmáticos de pesticidas en personas de distintos países, obteniéndose los niveles promedio para la población de cada país. Luego, se correlacionan con las tasas de mortalidad por cáncer de cada país. **¿A qué tipo de estudio corresponde?**

A Observacional
B Cohortes
C Experimental
D Ecológico
E De contraste de hipótesis

Respuesta D. En el estudio ecológico la unidad de análisis es un grupo (país, región), no el individuo: se correlacionan promedios de exposición con tasas de enfermedad. Es observacional, pero ecológico es la clasificación más específica. Su principal limitación es la falacia ecológica: la asociación entre grupos puede no cumplirse a nivel individual.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 45

En un estudio se realiza la medición de los niveles plasmáticos promedio de pesticidas, en la población de distintos países y se correlaciona con las tasas de mortalidad por cáncer. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

A Ecológico
B Cohortes
C Caso control
D Observacional
E Experimental

Respuesta A. Es un estudio ecológico clásico, sin embargo, vale la pena mencionar que también es un estudio de tipo observacional (ya que no es experimental).

▶ VER CLASE 7.01.3.026 Causalidad y sesgos

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.9 · Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos

QUÉ HAY QUE SABER

- Primero descartar azar, luego sesgo y confusión, y recién entonces evaluar causalidad.
- Error aleatorio (precisión): se reduce aumentando la muestra y se cuantifica con valor p e IC 95%. Sesgo (error sistemático, validez interna): no se corrige aumentando la muestra.
- Sesgos de selección: Berkson (casos y controles solo del hospital), trabajador sano, voluntario. De información: memoria (casos y controles), entrevistador, vigilancia o detección (a un grupo se le busca más, p. ej. anticonceptivos y control de presión más frecuente).
- Confusión: tercera variable asociada a la exposición y causa independiente de la enfermedad, sin ser paso intermedio (tabaco en café y cáncer de páncreas); se controla con estratificación, pareamiento o análisis multivariado.
- Bradford Hill: el único criterio indispensable es la temporalidad (la causa precede al efecto); suman fuerza, dosis-respuesta, plausibilidad, consistencia y cesación de la exposición.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 68

Según los criterios de causalidad de Bradford Hill, se pregunta cuál es el requisito indispensable para establecer una asociación causal. **¿Cuál es requisito para establecer una asociación causal?**

A Fuerza de asociación
B Plausibilidad biológica
C Respuesta dosis dependiente
D Secuencia temporal
E Asociación estadística

Respuesta D. La secuencia temporal es el único criterio de Bradford Hill absolutamente indispensable: si la causa no antecede al efecto, no puede ser la causa. Los demás criterios refuerzan la sospecha de causalidad, pero ninguno es obligatorio por sí solo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 32

Un estudio busca la asociación entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de hipertensión arterial, y concluye que hay mayor hipertensión en las pacientes que usaban anticonceptivos. Sin embargo, las pacientes que recibían anticonceptivos orales fueron controladas tres veces más seguido que las que no los recibían. **¿Qué sesgo se encuentra presente en el estudio descrito?**

A Sesgo de selección
B Sesgo de notificación
C Sesgo de exclusión
D Sesgo de vigilancia
E Sesgo del evaluador

Respuesta D. Es un sesgo de vigilancia o detección: al grupo que usaba anticonceptivos se le controló la presión arterial tres veces más seguido, así que era estadísticamente más probable detectar hipertensión en ese grupo solo por haberlo buscado más, no porque el fármaco necesariamente la produjera en esa magnitud.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Estudio retrospectivo de casos y controles evalúa si el consumo de antibióticos en el primer trimestre del embarazo se asocia a cardiopatías congénitas. Se entrevista a madres de 100 niños con cardiopatías complejas y a 200 madres de niños sanos. Las madres de los niños con cardiopatía recuerdan con detalle haber tomado fármacos durante la gestación, mientras que las madres de niños sanos no recuerdan haber tomado medicamentos, a pesar de que sí constaba en sus fichas clínicas. **¿A qué tipo de sesgo corresponde esta situación?**

A Sesgo de memoria
B Sesgo de Berkson
C Factor de confusión
D Sesgo del trabajador sano
E Error aleatorio

Respuesta A. Es el sesgo de memoria, típico de los estudios de casos y controles: las madres de niños enfermos recuerdan y reportan la exposición con más detalle que las madres de niños sanos, sobreestimando falsamente el riesgo, incluso cuando la ficha clínica muestra que ambos grupos estuvieron igualmente expuestos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 170

Un problema de los estudios de casos y controles es que, al ser retrospectivo, las personas evaluadas olvidan las situaciones a las que estuvieron expuestos. Aquello produce un tipo de error sistemático, que corresponde a un:

A Error de clasificación diferencial
B Sesgo de selección
C Sesgo de confusión
D Sesgo de información
E Error de clasificación no diferencial

Respuesta D. El sesgo de memoria es un tipo de sesgo de información o medida, que afecta al evaluado. Los errores de clasificación son aquellos...

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 75

El uso del enmascaramiento (doble ciego controlado) como medida en estudios epidemiológicos tiene como objetivo:

A Disminuir el sesgo de información
B Disminuir sesgo de selección (es de información, en específico los subtipos del evaluador y el evaluado, sesgo de selección sería realizar un estudio excluyendo de la muestra de estudio una población especifica y relevante)
C Darle mayor valor al estudio
D Disminuir el error aleatorio
E Hemograma y VHS

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Disminuir el sesgo de información).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 94

En un estudio se realiza la validación y estandarización de las encuestas a aplicar. ¿Qué tipo de sesgo se busca evitar?

A Sesgo de memoria
B Sesgo de información
C Sesgo de confusión
D Sesgo de notificación
E Sesgo del entrevistador

Respuesta B. Los sesgos de información o sesgos de medida son aquellos en los que la información obtenida está sesgada. En este caso se trata de un sesgo del instrumento de medición. Ver resumen de SP o una película de terror (son iguales).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 70

¿Qué tipo de sesgo se trata de evitar, al validar previamente los cuestionarios en un estudio?

A Sesgo de memoria
B Sesgo de información
C Sesgo de confusión
D Sesgo de selección
E Sesgo del entrevistador

Respuesta B. Los sesgos de información o medida se previenen con el doble ciego y con instrumentos de medición validados y calibrados.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2017 · PREGUNTA 73

La erradicación del Helicobacter pylori reduce significativamente la recidiva de la úlcera gastroduodenal, en comparación a aquellos casos en que no se erradica. Este es uno de los principales argumentos para afirmar la relación causal entre esta bacteria y dicha patología. ¿A qué criterio de causalidad de Bradtford Hills corresponde?

A Asociación
B Relación dosis efecto
C Plausibilidad biológica
D Cesación de la exposición
E Congruencia con el conocimiento científico existente

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Cesación de la exposición). De las opciones es la única aceptable.

▶ VER CLASE 7.01.3.027 Investigación epidemiológica

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.4 · Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

QUÉ HAY QUE SABER

- Investigación de un brote en orden: confirmar el diagnóstico y la existencia del brote (más casos que lo esperado), definir caso, buscar casos, describir por persona-lugar-tiempo, plantear y probar hipótesis (casos y controles) y aplicar medidas de control.
- Brote de ETA: ≥2 casos con alimento común; curva epidémica, tasa de ataque y riesgo relativo por alimento; agentes habituales Salmonella y Staphylococcus.
- Notificar a la SEREMI de Salud (autoridad sanitaria territorial) ante el brote; no basta avisar al director del hospital.
- Medidas inmediatas: inspección sanitaria, decomiso del alimento, coprocultivos a los afectados, profilaxis de contactos cuando corresponde.
- Comunicar resultados y evaluar el control.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

La SEREMI de Salud recibe la notificación de 25 personas con diarrea y vómitos 6 a 12 horas después de asistir a un matrimonio. Se decide iniciar una investigación epidemiológica. **Tras organizar el equipo de terreno, ¿cuál es el primer paso de la investigación del brote?**

A Publicar los resultados en la prensa
B Confirmar el diagnóstico y verificar la existencia del brote
C Diseñar un ensayo clínico con antibióticos
D Calcular odds ratio antes de definir qué es un caso
E Clausurar el local sin investigar

Respuesta B. La investigación de un brote sigue pasos ordenados: confirmar el diagnóstico y la existencia del brote (más casos que lo esperado), definir caso, buscar casos, describir según persona, lugar y tiempo, plantear y probar hipótesis (por ejemplo, con casos y controles), aplicar medidas de control y comunicar los resultados.

▶ VER CLASE **7.01.3.028** **Pruebas de screening (tamizaje) y diagnósticas**

DÓNDE SE ENSEÑA

Salud Pública 21.8 · Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC
Salud Pública 21.10 · Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos

QUÉ HAY QUE SABER

- Sensibilidad = VP/(VP+FN); especificidad = VN/(VN+FP). Son propiedades del test y no cambian con la prevalencia. Ejemplo: 92 de 100 enfermos positivos = sensibilidad 92%.
- Tamizaje exige alta sensibilidad (un negativo descarta); confirmación exige alta especificidad (un positivo confirma). ELISA para VIH: sensible, tamizaje; Western Blot: específico, confirmatorio.
- VPP y VPN dependen de la prevalencia: prevalencia alta sube VPP y baja VPN; prevalencia baja (tamizaje masivo) baja el VPP con muchos falsos positivos y sube el VPN.
- Razón de verosimilitud (+) = S/(1−E), >10 confirma; (−) = (1−S)/E, <0,1 descarta; no dependen de la prevalencia. Curva ROC: S vs 1−E; área 0,5 es azar, >0,9 excelente.
- Tamizaje no diagnostica, clasifica a personas asintomáticas; es prevención secundaria. Programas chilenos: PAP 25-64 años cada 3 años, mamografía 50-69 años cada 3 años, tamizaje neonatal universal.

PREGUNTAS · 8

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 60

¿Cuál de las siguientes características del Elisa permite detectar a los pacientes con infección por el VIH, en la población asintomática? **Seleccione la alternativa correcta:**

A Alta sensibilidad
B Baja especificidad
C Alta especificidad
D Alto valor predictivo positivo
E Alto valor predictivo negativo

Respuesta A. Un test de tamizaje debe detectar a todos los enfermos: necesita alta sensibilidad. Por eso un ELISA reactivo no es diagnóstico y requiere confirmación (en Chile, por el ISP).

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2016 · PREGUNTA 28

Se busca determinar la utilidad de una prueba diagnóstica. **¿Qué técnica es la más adecuada?**

A Elaboración de curvas de ROC
B Determinar la sensibilidad y especificidad de la prueba
C Determinar la sensibilidad de la prueba y la prevalencia de la enfermedad
D Determinar la especificidad y el valor predictivo negativo de la prueba
E Determinar el número necesario para tratar (NNT)

Respuesta B. El cálculo de la sensibilidad y la especificidad es la forma clásica de determinar la utilidad de una prueba diagnóstica. Las curvas ROC también sirven, pero solo para pruebas cuantitativas, y de hecho requieren primero calcular la sensibilidad y la especificidad en distintos puntos de corte.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2018 · PREGUNTA 43

Se pregunta por la característica obligatoria de una prueba de tamizaje. **Una prueba de tamizaje obligatoriamente debe tener:**

A Alta especificidad, sin importar la sensibilidad
B Alta sensibilidad, independiente de la especificidad
C Alto valor predictivo positivo y facilidad en su aplicación
D Bajo valor predictivo negativo y reproductibilidad
E Bajo costo y baja sensibilidad

Respuesta B. Una prueba de tamizaje debe tener alta sensibilidad, para detectar al máximo posible de enfermos y no dejar pasar casos, aunque su especificidad no sea tan alta; los falsos positivos que genere se resuelven después con una prueba confirmatoria más específica.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2019 · PREGUNTA 60

Se pregunta por la característica del ELISA que permite detectar a los pacientes con infección por VIH en la población asintomática. **¿Cuál de las siguientes características del ELISA permite detectar a los pacientes con infección por el VIH en la población asintomática?**

A Alta sensibilidad
B Baja especificidad
C Alta especificidad
D Alto valor predictivo positivo
E Alto valor predictivo negativo

Respuesta A. Las pruebas de tamizaje, como el ELISA para VIH en población asintomática, requieren una alta sensibilidad para no dejar pasar casos, tolerando una especificidad intermedia; los positivos se confirman después con Western Blot, que sí exige alta especificidad.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 122

Se pregunta cuál es la mejor estrategia para la detección temprana del cáncer testicular en la población en riesgo. **¿Cuál es la mejor estrategia para la detección temprana del cáncer testicular?**

A Niveles plasmáticos de alfafetoproteína

B Consultorios especializados para dolor testicular

C Campañas de autoexamen testicular

D Ecografías testiculares como prueba de detección

E Niveles plasmáticos de gonadotropina coriónica humana

Respuesta C. El autoexamen testicular es la estrategia que cumple los criterios de un tamizaje aplicable a toda la población en riesgo: es simple, no invasivo, de bajo costo y aceptable. La ecografía y los marcadores tumorales son exámenes diagnósticos, no herramientas de tamizaje masivo, y no se recomiendan de rutina en población asintomática.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Se evalúa un nuevo test rápido para antígeno de dengue comparándolo con la reacción de polimerasa en cadena (gold standard) en 500 pacientes con fiebre en zona endémica. De 100 pacientes con PCR positiva, el test rápido fue positivo en 92 y negativo en 8. De 400 pacientes con PCR negativa, el test fue negativo en 360 y positivo en 40. **¿Cuál es la Sensibilidad del nuevo test?**

A 92%

B 90%

C 88%

D 69,7%

E 8%

Respuesta A. La Sensibilidad se calcula sobre la columna de los verdaderamente enfermos: verdaderos positivos dividido en el total de enfermos, es decir 92 dividido en 100, igual a 92%. El 90% corresponde a la especificidad (360 de 400); el 69,7% sería un cálculo incorrecto que mezcla ambas columnas.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hospital tamiza cáncer pulmonar con tomografía computarizada de baja dosis en fumadores. Un estudio preliminar reporta que los pacientes con cáncer detectado por el tamizaje tienen una sobrevida a 5 años del 60 por ciento, comparado con solo un 20 por ciento en los que se diagnosticaron por síntomas como hemoptisis y baja de peso. Sin embargo, al revisar las defunciones, la mortalidad por cáncer pulmonar en la población tamizada es idéntica a la de la población no tamizada a los 10 años de seguimiento. **¿Cuál es el sesgo metodológico que explica este fenómeno?**

A Sesgo de adelanto diagnóstico (lead-time bias)

B Sesgo de duración (length-time bias)

C Factor de confusión no controlado

D Sesgo de selección de Berkson

E No existe ningún sesgo, el tamizaje realmente funciona

Respuesta A. Es el sesgo de adelanto diagnóstico: la sobrevida calculada desde el diagnóstico aumenta solo porque el tamizaje adelantó el momento en que se supo del cáncer, pero la mortalidad, que es el indicador que no se deja engañar, es idéntica entre tamizados y no tamizados. El diagnóstico se adelantó, pero la muerte no se postergó.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 141

¿Cuál es el mejor indicador para determinar si un test de tamizaje, para la detec- ción de cáncer, es efectivo?

A Disminución de la tasa de incidencia

B Disminución de la tasa de prevalencia

C Disminución de la tasa de letalidad

D Disminución de la tasa de mortalidad

E Aumento de la supervivencia de la enfermedad

Respuesta C. C? El tamizaje no baja la incidencia. La prevalencia baja tanto porque se mejoran, como porque se mueren. La letalidad es un buen indicador, porque al diagnosticar pre- cozmente, se evita la muerte. La mortalidad también sería un indicado bueno, menos exacta, pero más disponible.

▶ VER CLASE 7.01.3.029 Descripción sistemática de problemas

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.7 · Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

QUÉ HAY QUE SABER

- Descripción sistemática de un problema de salud: responde quién (persona: edad, sexo, ocupación), dónde (lugar) y cuándo (tiempo: tendencia, estacionalidad, conglomerados).
- Cuantifica la magnitud, identifica grupos de riesgo y genera hipótesis; es la etapa previa a buscar causas.
- Ejemplo: aumento de tuberculosis en una comuna se describe antes de plantear hipótesis.
- No confundir con medidas de asociación (etapa analítica) ni con sensibilidad (evaluación de pruebas).
- Se complementa con indicadores de frecuencia: incidencia, prevalencia, mortalidad específica y letalidad.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un equipo de salud detecta un aumento de casos de tuberculosis en su comuna y decide describir sistemáticamente el problema antes de plantear hipótesis sobre su causa. **¿Qué variables utiliza la epidemiología para describir sistemáticamente un problema de salud?**

A Persona, lugar y tiempo

B Sensibilidad, especificidad y valores predictivos

C Riesgo relativo, odds ratio y riesgo atribuible

D Agente, vector y reservorio exclusivamente

E Costo, beneficio y utilidad

Respuesta A. La descripción sistemática de un problema responde quién se enferma (persona: edad, sexo, ocupación), dónde (lugar) y cuándo (tiempo: tendencias, estacionalidad, conglomerados). Esto cuantifica su magnitud, identifica grupos de riesgo y genera hipótesis. Las medidas de asociación corresponden a la etapa analítica y la sensibilidad a la evaluación de pruebas diagnósticas.

▶ VER CLASE 7.01.3.030 Criterios de priorización de problemas

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.5 · Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

QUÉ HAY QUE SABER

- Criterios clásicos de priorización: magnitud (cuántos afecta: prevalencia, incidencia), trascendencia (gravedad e impacto: mortalidad, discapacidad, AVISA, costo social), vulnerabilidad (existencia de intervención eficaz) y factibilidad (recursos, aceptabilidad, viabilidad).
- Método de Hanlon: pondera magnitud, gravedad, eficacia de la solución y factibilidad.
- Se prioriza después de recolectar datos y escuchar a la comunidad en el diagnóstico participativo, no antes ni solo por prevalencia.
- La vulnerabilidad evalúa si existe una intervención eficaz que modifique el problema.
- Tras priorizar: plan de acción intersectorial con metas, indicadores y monitoreo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Tras su diagnóstico de situación, un CESFAM debe priorizar sus problemas de salud usando criterios clásicos: magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad. **¿Qué evalúa el criterio de vulnerabilidad?**

A La gravedad del problema y su impacto social y económico

B El número de personas afectadas

C Si existen intervenciones eficaces capaces de modificar el problema

D La disponibilidad de recursos y la aceptación de la comunidad

E La tendencia del problema en los últimos años

Respuesta C. En la priorización: magnitud es cuántos afecta (prevalencia, incidencia); trascendencia, su gravedad e impacto (mortalidad, discapacidad, años de vida perdidos, costo social); vulnerabilidad, la existencia de intervenciones eficaces para modificarlo; y factibilidad, si hay recursos, aceptabilidad y viabilidad para aplicarlas.

▶ VER CLASE 7.01.3.031 Estrategias de control de enfermedades infecciosas

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.4 · Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

QUÉ HAY QUE SABER

- Control de enfermedades infecciosas: vacunación masiva (mayor impacto, inmunidad de rebaño), notificación y vigilancia, estudio y quimioprofilaxis de contactos, saneamiento básico, aislamiento y cuarentena (complementarias y transitorias).
- Quimioprofilaxis: meningococo a contactos estrechos (convivientes o saliva compartida en 10 días) con rifampicina 600 mg c/12 h por 2 días o ciprofloxacino dosis única (ceftriaxona IM en embarazadas); coqueluche, azitromicina a convivientes y cuidadores de lactantes; hantavirus no tiene profilaxis farmacológica, solo seguimiento clínico.
- Notificación inmediata ante sospecha, sin esperar laboratorio, para permitir profilaxis oportuna; la vacuna evalúa su éxito por baja de incidencia.
- Brotes de ETA: investigación, inspección y decomiso del alimento, coprocultivos.
- El médico general notifica, indica profilaxis y educa; la SEREMI conduce la investigación epidemiológica.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2025 · PREGUNTA 56

Durante una pandemia respiratoria, el Ministerio de Salud debe decidir la intervención de salud pública con mayor impacto para reducir la mortalidad poblacional a largo plazo. **¿Cuál es la medida más eficaz?**

A Profilaxis antibiótica masiva

B Desinfección ambiental de espacios públicos

C Cuarentena de contactos

D Vacunación masiva de la población

E Aislamiento de casos positivos solamente

Respuesta D. La vacunación masiva es la estrategia de control con mayor impacto sobre la mortalidad por infecciones respiratorias: protege al vacunado y genera inmunidad de rebaño. Cuarentena y aislamiento son medidas complementarias y transitorias; la profilaxis antibiótica no sirve contra virus.

▶ VER CLASE 7.01.3.032 Estrategias de control de enfermedades crónicas prioritarias (cáncer, cardiovasculares)

DÓNDE SE ENSEÑA **Diabetes** 1.5 · Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular

QUÉ HAY QUE SABER

- Prioridades: cáncer y enfermedades cardiovasculares son primeras causas de muerte en Chile; la estrategia se basa en prevención primaria (tabaco, alimentación, actividad física), detección precoz y tratamiento oportuno (GES).
- Factores de riesgo comunes y modificables: tabaquismo, hipertensión, dislipidemia, diabetes, obesidad, sedentarismo y alcohol; abordaje poblacional (etiquetado de alimentos, ley del tabaco) más intervención individual en APS.
- Programa de Salud Cardiovascular en APS: pesquisa en el Examen de Medicina Preventiva, control por riesgo cardiovascular y metas terapéuticas con farmacoterapia GES (HTA, DM2, dislipidemia).
- Tamizaje con evidencia: PAP (25-64 años), mamografía (50-69 años), cáncer colorrectal y gástrico según programas; el tamizaje es prevención secundaria y debe evaluarse por reducción de mortalidad específica.
- Estilo de vida: ≥150 min/semana de actividad aeróbica moderada repartida en ≥3 días más ejercicios de resistencia 2-3 veces por semana; alimentación saludable y cese del tabaco.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 6

Se pregunta cuál es el mejor indicador para determinar si un programa de tamizaje del cáncer de mama es efectivo. **¿Cuál es el mejor indicador para determinar si un programa de tamizaje del cáncer de mama es efectivo?**

A Tasa de incidencia de cáncer de mama

B Tasa de prevalencia de cáncer de mama

C Tasa de letalidad de cáncer de mama

D Tasa de mortalidad de cáncer de mama

E Tasa de positividad de las pruebas de tamizaje

Respuesta D. El indicador válido para evaluar un tamizaje es la reducción de la mortalidad. El tamizaje no reduce la incidencia, porque no evita que aparezca el cáncer, solo lo detecta antes; y la sobrevida o la letalidad calculadas desde el diagnóstico pueden estar infladas por el sesgo de adelanto o el de duración.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

El Ministerio de Salud busca reducir la mortalidad cardiovascular del país y evalúa distintas medidas. Siguiendo a Geoffrey Rose, distingue entre estrategias dirigidas a individuos de alto riesgo y estrategias poblacionales. **¿Cuál de las siguientes corresponde a una estrategia poblacional?**

A Realizar angioplastía precoz en el infarto agudo

B Indicar estatinas a pacientes con riesgo cardiovascular alto

C Ingresar a los hipertensos al Programa de Salud Cardiovascular

D Reducir el contenido de sodio del pan mediante un acuerdo con la industria panificadora

E Prescribir antiagregantes a pacientes con enfermedad coronaria

Respuesta D. La estrategia poblacional desplaza la distribución del factor de riesgo en toda la población, como reducir la sal del pan, la ley de etiquetado de alimentos o los impuestos al tabaco. Logra gran impacto porque la mayoría de los eventos ocurre en personas de riesgo moderado. Las demás opciones son estrategias de alto riesgo o tratamiento individual.

▶ VER CLASE 7.01.3.033 Bases conceptuales de la seguridad social

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.1 · Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- Seguridad social: protección que la sociedad otorga ante contingencias (enfermedad, vejez, invalidez, cesantía, muerte) mediante prestaciones y subsidios.
- Principios clásicos: universalidad (cubre a toda la población), integralidad (todas las contingencias), solidaridad (aporta según su capacidad y recibe según su necesidad; subsidio cruzado), suficiencia (prestaciones adecuadas) y unidad (coordinación administrativa).
- Modelos: Bismarck (cotización de trabajadores y empleadores), Beveridge (financiamiento por impuestos, cobertura universal).

- En Chile el sistema es mixto: cotización legal de salud de 7% de la remuneración imponible más aporte fiscal.
- La solidaridad se expresa en FONASA; en ISAPRE el plan depende del contrato individual y el riesgo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En un sistema de seguridad social en salud, las personas de mayores ingresos cotizan más, y los aportes de los sanos y de quienes más ganan financian la atención de los enfermos y de quienes menos tienen. **¿Qué principio de la seguridad social describe esta situación?**

A Unidad
B Universalidad
C Integralidad
D Suficiencia
E Solidaridad

Respuesta E. Los principios clásicos de la seguridad social son: universalidad (cubre a toda la población), integralidad (cubre todas las contingencias), solidaridad (cada uno aporta según su capacidad y recibe según su necesidad), suficiencia (prestaciones adecuadas a la necesidad) y unidad (coordinación administrativa). El subsidio cruzado entre ingresos y riesgos es solidaridad.

▶ VER CLASE 7.01.3.034 Desarrollo histórico de seguridad social y atención de salud

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.1 · Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- Hitos históricos: 1924 Caja del Seguro Obrero Obligatorio; 1952 Servicio Nacional de Salud (SNS), que unificó la atención estatal; 1979-1981 reforma: Sistema Nacional de Servicios de Salud, FONASA e ISAPRE; 2005 comienzo del régimen GES (AUGE).
- Ley Ricarte Soto (20.850) para tratamientos de alto costo y Ley de derechos y deberes de los pacientes (20.584) son hitos posteriores.
- El SNS integró prevención y asistencia con base estatal; la reforma de 1981 introdujo la coexistencia de subsistema público y privado.
- Ley 19.966 (2004) creó el Régimen de Garantías Explícitas en Salud.
- Evolución: de seguro de obreros a cobertura universal con garantías exigibles.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En la historia de la salud chilena, en 1952 se integraron diversos servicios asistenciales, sanitarios y de beneficencia en una única institución estatal que pasó a atender a obreros e indigentes y a desarrollar programas de salud pública a nivel nacional. **¿Qué institución se creó en ese año?**

A El Fondo Nacional de Salud (FONASA)
B El Servicio Nacional de Salud (SNS)
C Las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE)
D La Caja del Seguro Obrero Obligatorio
E El Régimen de Garantías Explícitas en Salud

Respuesta B. En 1924 se creó la Caja del Seguro Obrero Obligatorio; en 1952, el Servicio Nacional de Salud, que unificó la atención estatal. A partir de 1979 y 1981 se reorganizó el sistema, creando el Sistema Nacional de Servicios de Salud, FONASA y las ISAPRE. En 2005 comenzó el régimen GES (AUGE).

▶ VER CLASE 7.01.3.035 Funciones de los sistemas de atención de salud

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.1 · Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- Funciones de los sistemas de salud: rectoría (conducción, políticas, normas y fiscalización), financiamiento, aseguramiento y provisión de servicios; la generación de recursos (personal, infraestructura) sostiene las anteriores.
- En Chile: rectoría del MINSAL (con subsecretarías y SEREMI); financiamiento y aseguramiento por FONASA e ISAPRE; provisión por la red de Servicios de Salud y prestadores privados.
- La Superintendencia de Salud fiscaliza a FONASA, ISAPRE y prestadores, y vela por el cumplimiento de las garantías GES.
- El ISP es el laboratorio nacional de referencia y regula medicamentos; no fiscaliza el dinero.
- Pregunta tipo: quien ejerce la rectoría es el Ministerio de Salud, no FONASA ni los Servicios de Salud.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Según la OMS, todo sistema de salud cumple funciones de rectoría, financiamiento, aseguramiento y provisión de servicios. En Chile, estas funciones están separadas entre distintas instituciones. **¿Qué institución ejerce la función de rectoría del sistema de salud chileno?**

A Los Servicios de Salud

B El Fondo Nacional de Salud (FONASA)

C El Ministerio de Salud

D La Superintendencia de Salud

E La Central de Abastecimiento (CENABAST)

Respuesta C. La rectoría (conducción, formulación de políticas y normas) corresponde al Ministerio de Salud, a través de sus subsecretarías y las SEREMI. FONASA ejerce el financiamiento y aseguramiento público; los Servicios de Salud gestionan la red asistencial que provee las prestaciones; la Superintendencia fiscaliza a FONASA, ISAPRE y prestadores; y CENABAST abastece de fármacos e insumos.

▶ VER CLASE 7.01.3.036 Organización actual del sistema de salud chileno

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.1 · Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- MINSAL rector y normativo, con Subsecretaría de Salud Pública (vigilancia epidemiológica y SEREMI) y Subsecretaría de Redes Asistenciales (gestiona los Servicios de Salud). Superintendencia de Salud: autónoma, fiscaliza.
- Dos subsistemas: FONASA (seguro público, solidario, mayoría de la población) e ISAPRES (seguros privados con plan individual); también FFAA con su propio sistema.
- FONASA tramos A, B, C y D según ingreso del grupo familiar; tramo A sin derecho a Modalidad Libre Elección; con Copago Cero (2022) los cuatro tramos tienen gratuidad total en Modalidad de Atención Institucional.
- Financiamiento: cotización 7% más aporte fiscal; la APS municipal se financia con aporte per cápita que financia el Plan de Salud Familiar.
- Red asistencial en tres niveles: primario (CESFAM, CECOSF, postas rurales; resuelve 80-90% de consultas), secundario (CDT, CAE, COSAM) y terciario (hospitales de alta complejidad).

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 126

Una empresa extranjera dedicada a otorgar prestaciones en salud decide iniciar sus operaciones en Chile, para lo cual solicita saber cuál es la institución que actúa como laboratorio de referencia para todos los laboratorios, tanto públicos como privados, en el país. **¿Cuál es la respuesta correcta?**

A Central Nacional de Abastecimiento

B Instituto de Salud Pública

C Superintendencia de Salud

D Servicio Médico Legal

E Secretaría Regional Ministerial de Salud

Respuesta B. El Instituto de Salud Pública actúa como laboratorio nacional y de referencia, supervisa laboratorios de exámenes médicos y de producción de medicamentos, autoriza y fiscaliza medicamentos y dispositivos médicos, y realiza vigilancia sanitaria y epidemiológica de laboratorio.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 129

¿Cuál de las siguientes instituciones es la encargada de supervisar el funcionamiento del sistema de salud público y privado en Chile, fiscalizar a FONASA y a las instituciones previsionales de salud, y velar por el cumplimiento de las garantías GES? **¿Cuál es la institución correcta?**

A Instituto de Salud Pública

B Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud

C Ministerio de Salud, por medio de la Subsecretaría de Salud Pública

D Superintendencia de Salud

E Fondo Nacional de Salud (FONASA)

Respuesta D. La Superintendencia de Salud es el organismo autónomo encargado de supervisar y fiscalizar tanto al sistema público como privado, incluyendo a FONASA, a las ISAPRES y el cumplimiento de las garantías GES.

▶ VER CLASE 7.01.3.037 Política sanitaria y objetivos sanitarios en Chile

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.1 · Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- Política sanitaria: se formaliza en los Objetivos Sanitarios de la Década, plasmados en la Estrategia Nacional de Salud, que fija ejes, metas de impacto e indicadores del período y orienta la planificación de la red.
- Los objetivos se miden con indicadores de impacto (mortalidad, esperanza de vida, discapacidad) y de equidad.
- Instrumentos relacionados: GES (garantías), Ley Ricarte Soto, Programa de Inmunizaciones, planes de salud comunal.
- El Código Sanitario regula materias sanitarias; no contiene los objetivos sanitarios.

- Rectoría y definición de políticas: MINSAL; ejecución por Servicios de Salud y APS municipal.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

El Ministerio de Salud define, para el período 2021-2030, los objetivos de impacto que el país espera lograr en salud de la población, junto con sus metas e indicadores, para orientar la planificación de toda la red. **¿Qué instrumento contiene estos objetivos sanitarios?**

A El arancel de FONASA
B La Ley Ricarte Soto
C El Código Sanitario
D El Plan de Salud Comunal
E La Estrategia Nacional de Salud

Respuesta E. Los Objetivos Sanitarios de la Década se formalizan en la Estrategia Nacional de Salud, que fija ejes estratégicos, metas de impacto e indicadores para el período y orienta la planificación de la red. El Código Sanitario regula materias sanitarias, la Ley Ricarte Soto financia tratamientos de alto costo y el Plan Comunal es la programación local.

▶ VER CLASE 7.01.3.038 Definición, estructura y funciones de los subsistemas en Chile

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.1 · Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- FONASA: seguro público; modalidad de atención institucional (red pública, gratuita en los 4 tramos desde Copago Cero) y modalidad Libre Elección (bonos en privados en convenio; tramo A no accede).
- ISAPRES: seguros privados con contrato individual y plan de salud según ingreso y riesgo; tienen GES con tope de copago 20% y deducible anual.
- Servicios de Salud: organismos descentralizados que gestionan la red pública asistencial de un territorio; APS municipal con CESFAM, CECOSF y postas.
- Superintendencia de Salud: autónoma, fiscaliza FONASA, ISAPRES y prestadores; la acreditación de prestadores y el Registro Nacional de Prestadores Individuales dependen de ella.
- SEREMI: autoridad sanitaria regional, autoriza el funcionamiento sanitario de establecimientos y conduce la vigilancia.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Hombre de 58 años, afiliado a FONASA con ingresos de 2 ingresos mínimos mensuales (Tramo D), consulta en el CESFAM por dolor lumbar mecánico. El médico general le indica reposo, analgesia y le solicita una radiografía de columna en el hospital del área. El paciente pregunta cuánto deberá pagar por la consulta y por la radiografía. **¿Cuál es la respuesta correcta sobre el costo de esta atención?**

A Deberá pagar el 20% del arancel de FONASA correspondiente al Tramo D
B El costo será de $0, ya que la atención se realiza en la Modalidad de Atención Institucional
C Deberá pagar el 10% del valor de la radiografía, según el arancel del Tramo D
D No tiene derecho a la radiografía en el hospital público por ser Tramo D
E Debe elegir entre pagar en la red pública o comprar un bono de Libre Elección con descuento

Respuesta B. Desde el Copago Cero vigente desde 2022, todos los tramos de FONASA (A, B, C y D) tienen atención 100% gratuita en la Modalidad de Atención Institucional, incluyendo consultas, exámenes y hospitalizaciones en la red pública. El copago solo existe si el paciente elige voluntariamente la Modalidad Libre Elección en el sector privado.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 95

Las instituciones de salud previsional y el seguro público de salud tienen en salud que:

A Administrar el seguro de cotización individual
B Administran el seguro público de salud
C Administrar los fondos para las garantías de salud, comprendidas en el plan AUGE
D Administran el seguro general de salud
E Dan prestaciones de salud

Respuesta C. Tanto las Isapres, como Fonasa administran los fondos AUGE. Las Isapres adminstran el seguro de cotización individual y Fonasa el seguro público. No sé qué es el seguro general. Ninguna dan prestaciones de salud, porque son seguros, no prestadores,

▶ VER CLASE 7.01.3.039 Concepto y descripción de la red asistencial chilena

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.1 · Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- Red asistencial pública en tres niveles: primario (CESFAM, CECOSF, postas rurales, SAPU, SAR; puerta de entrada obligatoria; resuelve 80-90% de las consultas), secundario (especialidad ambulatoria, CDT, CAE, COSAM) y terciario (hospitales de alta complejidad con camas críticas y cirugía mayor).
- Se accede al nivel secundario por interconsulta oficial desde APS, no por decisión directa del paciente.

- SAPU: urgencia básica adosada al CESFAM, tardes, noches y festivos, con electrocardiograma y laboratorio rápido. SAR: más resolutivo, 24 h o extendido, con radiografía digital y laboratorio con troponina y dímero D.
- COSAM (salud mental ambulatoria) es nivel secundario; CESFAM, CECOSF, posta rural y hospital comunitario son de APS.
- Referencia (hacia mayor complejidad) y contrarreferencia (retorno a APS) aseguran la continuidad del cuidado.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 166

Un médico recién llegado a un Servicio de Salud debe conocer el nivel de atención de los establecimientos de su red asistencial para derivar correctamente a sus pacientes. **¿Cuál de los siguientes corresponde a un centro de atención secundaria?**

A CESFAM
B CECOSF
C Posta de salud rural
D Hospital comunitario de familia
E COSAM

Respuesta E. El COSAM es un centro de especialidad ambulatoria en salud mental, por lo que pertenece al nivel secundario. CESFAM, CECOSF, posta de salud rural y hospital comunitario de salud familiar son establecimientos de atención primaria.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 31

¿Cuál de las siguientes instituciones corresponde a un centro de salud secundaria?

A Posta de Salud Rural
B CESFAM (Centro de Salud Familiar)
C COSAM (Centro de Salud Mental)
D CECOSF (Centro Comunitario de Salud Familiar)
E Hospital comunitario

Respuesta A. Diagnóstico: Posta de Salud Rural (opción A).

▶ VER CLASE 7.01.3.040 Beneficios de la seguridad social y rol del médico en su acceso

DÓNDE SE ENSEÑA

Salud Pública 21.2 · Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos
Salud Pública 21.3 · Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM)

QUÉ HAY QUE SABER

- Beneficios de la seguridad social en salud: GES (87 problemas con 4 garantías de acceso, oportunidad, protección financiera y calidad), Ley Ricarte Soto (alto costo, cobertura universal y copago 0), Copago Cero en FONASA, PNAC y PACAM, licencia médica y subsidio.
- Rol del médico: informar y dejar constancia de la sospecha o confirmación GES en el Formulario de Constancia firmado por médico y paciente (no hacerlo es falta grave sancionable por la Superintendencia); tramitar derivación a especialista tratante para Ricarte Soto.
- Si se vence el plazo GES: reclamo escrito del paciente al asegurador dentro de 30 días; el asegurador tiene 48 h hábiles para designar segundo prestador (10 días corridos, hasta 30 en complejas); si falla, Superintendencia designa tercer prestador en 48 h hábiles a costo del asegurador.
- Garantía de protección financiera: copago tope 20% en ISAPRE (0% en FONASA) y deducible anual; Ricarte Soto y PNAC son universales, sin importar la previsión.
- PACAM: ≥70 años FONASA con EMPAM y vacunas al día, sin evaluación socioeconómica ni certificado de desnutrición.

PREGUNTAS · 4

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 64 años con diagnóstico confirmado de artrosis de cadera con indicación de endoprótesis total (Problema GES N.° 37) tiene su plazo legal de tratamiento quirúrgico vencido por más de 15 días en el hospital público correspondiente. **¿Cuál es la conducta correcta que debe seguir el paciente?**

A Presentar un reclamo formal por incumplimiento de Garantía de Oportunidad ante FONASA, que dispondrá de 48 horas para designar un segundo prestador
B Acudir directamente a un tribunal civil para interponer un recurso de protección contra el hospital
C Operarse en una clínica privada de forma autónoma y exigir el reembolso del 100% de la cuenta
D Ingresar una solicitud de mediación prejudicial ante el Consejo de Defensa del Estado
E Exigir al director del hospital una compensación económica diaria por cada día de retraso

Respuesta A. Ante el vencimiento del plazo de la Garantía de Oportunidad, la Ley 19.966 establece la vía administrativa: reclamo ante el asegurador, que tiene 48 horas hábiles para designar un segundo prestador que otorgue la prestación dentro de 10 días corridos.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Una paciente de 42 años diagnosticada de artritis reumatoide refractaria a metotrexato y leflunomida requiere inicio de un fármaco biológico de alto costo (adalimumab) contemplado en el decreto de la Ley Ricarte Soto. La paciente se encuentra afiliada a una ISAPRE. **¿Cuál es la cobertura financiera que le corresponde según la ley?**

A Cien por ciento de cobertura gratuita financiada por el Estado, sin importar su previsión de salud

B Ochenta por ciento de cobertura con un copago del veinte por ciento con cargo al deducible GES de su plan

C Cincuenta por ciento de financiamiento si sus ingresos familiares superan un cierto tope

D La Ley Ricarte Soto solo rige para afiliados a FONASA, por lo que la ISAPRE debe financiarlo con un seguro catastrófico

E Debe pagar la totalidad del fármaco y solicitar un reembolso anual con tope ante el Ministerio de Hacienda

Respuesta A. La Ley 20.850 tiene cobertura universal para todos los habitantes del país que cumplan los criterios clínicos del decreto, sin distinción de previsión de salud, y la cobertura es totalmente gratuita para el beneficiario.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un paciente de 46 años, afiliado a FONASA, tiene diagnóstico confirmado de hernia del núcleo pulposo lumbar con indicación quirúrgica garantizada por GES. El plazo legal para la cirugía venció hace 20 días y el hospital aún no agenda la intervención. **¿Cuál es la conducta correcta que debe seguir el paciente?**

A Presentar un reclamo formal por escrito ante FONASA por incumplimiento de la Garantía de Oportunidad

B Solicitar directamente a la Superintendencia de Salud que le designe un tercer prestador

C Renunciar al GES para operarse por su cuenta y pedir reembolso posterior

D Esperar sin plazo definido, ya que la garantía de oportunidad no aplica a cirugías electivas

E Exigir al director del hospital una compensación económica por cada día de atraso

Respuesta A. Ante el vencimiento de la Garantía de Oportunidad, el primer paso es el reclamo formal ante el asegurador, FONASA en este caso, dentro de 30 días. Recién si FONASA no designa un segundo prestador en 48 horas, o este también incumple, corresponde acudir a la Superintendencia de Salud.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un hombre de 38 años, afiliado a una ISAPRE, es diagnosticado con hipertensión arterial pulmonar grave, patología incluida en el decreto de la Ley Ricarte Soto. Su médico especialista indica un tratamiento vasodilatador específico de alto costo, disponible en un centro acreditado por el MINSAL. **¿Cuál es la cobertura financiera que le corresponde a este paciente?**

A Cien por ciento de cobertura, sin copago, financiada por el Estado

B Ochenta por ciento de cobertura, con veinte por ciento de copago según su plan de ISAPRE

C Cobertura solo si renuncia a su ISAPRE y se afilia a FONASA

D Cincuenta por ciento de cobertura si supera el deducible anual de su plan

E Debe pagar el tratamiento y solicitar reembolso posterior a su ISAPRE

Respuesta A. La Ley Ricarte Soto cubre de forma universal, sin importar la previsión, y con financiamiento 100% estatal, sin copago, para todo paciente que cumpla el criterio clínico del decreto, siempre que se trate por un especialista en un centro acreditado.

▶ VER CLASE 7.01.3.041 Conceptos de administración y gestión

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.15 · Gestión y Administración en Salud: Demografía, Planificación, Programación, Organización y Dirección

QUÉ HAY QUE SABER

- Administración: proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar recursos para lograr los objetivos de una organización; gestión es su aplicación para obtener resultados (eficacia, eficiencia, efectividad).
- Eficacia: logro de objetivos; eficiencia: relación entre resultados y recursos usados; efectividad: logro del objetivo en condiciones reales; equidad y calidad como atributos de los servicios de salud.
- Niveles de gestión: estratégico (directivo), táctico (intermedio) y operativo (equipos clínicos); en la red pública, Servicios de Salud, hospitales (autogestionados) y APS municipal.
- Ciclo administrativo: planificación, organización, dirección y control/evaluación.
- El médico general participa en la gestión clínica: uso racional de recursos, metas sanitarias, registro y calidad.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Dos CESFAM implementan el mismo programa de control de hipertensión y ambos logran que el 70% de sus pacientes alcance la meta de presión arterial. Sin embargo, el CESFAM A lo consigue con la mitad del costo y de horas profesionales que el CESFAM B. **¿Qué atributo de gestión es mayor en el CESFAM A?**

A Eficacia
B Equidad
C Efectividad
D Eficiencia
E Cobertura

Respuesta D. Eficacia es lograr el resultado en condiciones ideales; efectividad, lograrlo en condiciones reales; y eficiencia, la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados. Ambos centros tienen igual efectividad, pero el A obtiene el mismo resultado con menos recursos, por lo que es más eficiente.

▶ VER CLASE 7.01.3.042 Planificación y programación en salud

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.15 · Gestión y Administración en Salud: Demografía, Planificación, Programación, Organización y Dirección

QUÉ HAY QUE SABER

- Planificación: definir diagnóstico, objetivos, metas, actividades, recursos y plazos; es el primer momento del ciclo administrativo.
- Niveles: estratégica (largo plazo), táctica o programación (mediano) y operativa (corto, plan anual); en salud se parte del diagnóstico de situación y la priorización de problemas.
- Programación: traducir los objetivos en actividades, rendimientos, recursos y cronograma, con responsables e indicadores.
- Objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes, con plazo); metas cuantificadas con indicadores.
- En Chile: Objetivos Sanitarios, Estrategia Nacional de Salud, planes de salud comunales y metas sanitarias de APS.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2019 · PREGUNTA 4

En la gestión de salud se distinguen distintos niveles de planificación de las acciones. **En gestión de salud, ¿cuál es la diferencia entre planificación y programación?**

A La planificación se refiere a objetivos y recursos específicos, mientras que la programación es global
B La planificación es a largo plazo, mientras que la programación es anual
C La programación, a diferencia de la planificación, debe ser concordante con la misión y la visión de la institución
D La planificación se basa en lo determinado con la programación
E La planificación se relaciona con los costos y recursos de actividades concretas y la programación con el presupuesto general del proyecto

Respuesta B. La planificación es el proceso global y estratégico, a mediano o largo plazo, que define objetivos y prioridades. La programación la operacionaliza en el corto plazo, habitualmente anual, detallando actividades, metas, recursos y responsables. Por eso la programación deriva de la planificación, y no al revés.

▶ VER CLASE 7.01.3.043 Formulación de programas

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.15 · Gestión y Administración en Salud: Demografía, Planificación, Programación, Organización y Dirección

QUÉ HAY QUE SABER

- Programa de salud: conjunto organizado de actividades para resolver un problema priorizado en una población objetivo, con objetivos, metas, recursos y evaluación.
- Formulación: diagnóstico y priorización del problema, definición de población objetivo, objetivos general y específicos, metas, actividades, recursos, cronograma, responsables e indicadores de evaluación.
- Evaluación según estructura, proceso, resultado e impacto: cobertura y tiempos de atención son indicadores de proceso; la mortalidad específica es indicador de impacto.
- Criterios de priorización: magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad.
- Ejemplos de programas nacionales: Inmunizaciones, PNAC, Salud Cardiovascular, Chile Crece Contigo.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un CESFAM formula su programa de inmunizaciones de invierno. Entre sus componentes escribe: vacunar contra la influenza al 85% de los adultos de 65 años y más inscritos, antes del 30 de junio. **¿A qué componente del programa corresponde este enunciado?**

A Misión institucional

B Objetivo general

C Actividad

D Meta

E Diagnóstico

Respuesta D. Un programa se formula con diagnóstico, objetivos (general y específicos), metas, actividades, recursos y evaluación. La meta es un objetivo cuantificado en magnitud, plazo y población: cuánto, a quiénes y para cuándo. El objetivo general es más amplio (reducir la morbimortalidad por influenza) y la actividad es la acción concreta (vacunar en operativos).

▶ VER CLASE 7.01.3.044 Organización: principios y características estructurales y funcionales de las organizaciones

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.15 · Gestión y Administración en Salud: Demografía, Planificación, Programación, Organización y Dirección

QUÉ HAY QUE SABER

- Organización: estructura formal que divide el trabajo y coordina funciones para lograr objetivos; principios clásicos: división del trabajo, jerarquía o cadena de mando, unidad de mando, autoridad y responsabilidad, especialización y coordinación.
- Estructura: organigrama; tipos lineal, funcional, matricial; centralización vs descentralización; amplitud de control.
- Organización formal (definida por estatutos) vs informal (relaciones espontáneas del grupo).
- En salud: Servicios de Salud con hospitales autogestionados, direcciones de APS municipales y equipos de cabecera por sector.
- Una organización eficaz define claramente cargos, funciones, flujos de comunicación y responsables.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En un hospital, los técnicos en enfermería de un servicio reciben instrucciones contradictorias de la enfermera supervisora, del jefe de servicio y del jefe de turno médico, lo que genera confusión y errores. **¿Qué principio de la organización se está vulnerando?**

A Delegación de autoridad

B Tramo de control

C Descentralización

D Especialización

E Unidad de mando

Respuesta E. La unidad de mando establece que cada trabajador debe recibir órdenes de un solo jefe directo, para evitar instrucciones contradictorias. El tramo de control se refiere al número de subordinados que un jefe puede dirigir eficazmente; la delegación, a transferir autoridad hacia niveles inferiores; y la especialización, a la división del trabajo.

▶ VER CLASE 7.01.3.045 Dirección: funciones de la dirección, liderazgo, comunicaciones, coordinación

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.15 · Gestión y Administración en Salud: Demografía, Planificación, Programación, Organización y Dirección

QUÉ HAY QUE SABER

- Dirección: guiar al equipo hacia los objetivos mediante liderazgo, motivación, comunicación y coordinación; es el momento de ejecución del ciclo administrativo.
- Liderazgo: autocrático, democrático o participativo, y laissez-faire; el líder en salud promueve trabajo en equipo y toma de decisiones compartidas.
- Comunicación efectiva: clara, bidireccional, oportuna y con retroalimentación; barreras: ruido, jerarquía, falta de información.
- Coordinación: articula actividades entre áreas y niveles de la red para evitar duplicidad.
- Motivación y manejo de conflictos son funciones directivas; la delegación con responsabilidad aumenta la eficiencia.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 120

Se produce un accidente de tránsito de alta energía fuera del horario laboral, en el que un grupo de pacientes resulta lesionado de gravedad. Son trasladados al servicio de urgencia, donde los recibe el médico de turno y son hospitalizados para su tratamiento médico y quirúrgico. La prensa exige información inmediata sobre el estado de los pacientes. **¿Quién debe realizar esta comunicación?**

A El médico de turno

B El director del hospital

C El encargado de relaciones públicas del hospital

D La enfermera jefe del servicio de urgencia

E El personal administrativo del hospital

Respuesta B. La comunicación oficial de la institución hacia los medios es una función de la dirección: corresponde al director del hospital o a quien él designe como vocero, resguardando la confidencialidad de los pacientes (Ley 20.584). El médico de turno informa a los pacientes y familiares, no a la prensa; relaciones públicas apoya, pero no es la autoridad.

▶ VER CLASE 7.01.3.046 Evaluación y control: conceptos, tipos de evaluación

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.10 · Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos

QUÉ HAY QUE SABER

- Evaluación: compara lo logrado con lo planificado; control: corrige desviaciones. Tipos según momento: ex ante, concurrente (monitoreo) y ex post.
- Según componente: estructura (recursos), proceso (actividades; cobertura, tiempos de atención), resultado e impacto (cambio final en salud de la población; mortalidad específica).
- Eficacia (logro de objetivos), efectividad (en condiciones reales) y eficiencia (resultados en relación con recursos).
- Ejemplo: en un programa de detección precoz de cáncer de mama, la mortalidad específica es el indicador de impacto; en tamizaje se desconfía de sobrevida a 5 años por sesgo de adelanto y de duración.
- Tamizaje: criterios de Wilson y Jungner (problema importante, fase preclínica prolongada, test simple y de alta sensibilidad, tratamiento eficaz que rinde más en fase precoz, costo razonable, proceso continuo).

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2025 · PREGUNTA 118

En un programa de detección precoz de cáncer de mama se mide periódicamente la tasa de mortalidad específica por esta enfermedad. **¿Qué función cumple la medición de la tasa de mortalidad específica por dicha enfermedad?**

A Permite determinar el grado de cobertura del programa

B Contribuye a evaluar la calidad del proceso de atención en el programa

C Permite obtener una variable indirecta que refleja la efectividad del programa

D Permite evaluar la eficiencia del proceso de aplicación del programa

E Refleja el impacto del programa

Respuesta E. La evaluación de programas distingue estructura, proceso, resultado e impacto. La mortalidad específica por cáncer de mama es el indicador de impacto del tamizaje, porque mide el cambio final en la salud de la población, que es su objetivo. La cobertura y los tiempos de atención son indicadores de proceso; la eficiencia relaciona resultados con recursos.

▶ VER CLASE 7.01.3.047 Auditoría y acreditación

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.2 · Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos

QUÉ HAY QUE SABER

- Acreditación: proceso periódico, formal y externo de evaluación de la calidad y seguridad del paciente en prestadores institucionales; la realiza la Superintendencia de Salud (Intendencia de Prestadores), con entidades acreditadoras.
- Es el mecanismo de exigibilidad de la garantía de calidad GES: solo profesionales inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales y establecimientos acreditados pueden otorgar prestaciones GES.
- Autorización sanitaria de funcionamiento: la otorga la SEREMI de Salud; no es lo mismo que acreditar.
- Un prestador no acreditado que otorga una prestación GES vulnera la garantía de calidad aunque la atención clínica sea buena.
- Auditoría: revisión sistemática e independiente de procesos o registros (clínicos, financieros) para verificar cumplimiento de normas y proponer mejoras.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 18

¿A qué tipo de garantía corresponde el registro de los profesionales de la salud en el Registro de Prestadores Individuales, llevado por la Superintendencia de Salud, en contexto del programa de Garantías Explícitas de Salud (GES)? **¿Cuál es la garantía correcta?**

A Garantía de acceso universal

B Garantía de protección financiera

C Garantía de calidad en la atención

D Garantía de oportunidad en la atención

E Garantía de acceso a la información

Respuesta C. El registro de prestadores individuales y la acreditación de prestadores institucionales ante la Superintendencia de Salud son el mecanismo de exigibilidad de la Garantía de Calidad. El acceso a la información no forma parte de las cuatro garantías GES.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 96

En el sistema de salud chileno existen instituciones encargadas de garantizar la calidad de los prestadores. **¿Qué institución es la encargada de acreditar y autorizar a los prestadores individuales de salud y a los centros de salud?**

A La Superintendencia de Seguridad Social

B La autoridad regional sanitaria

C La Superintendencia de Salud

D FONASA

E La municipalidad

Respuesta C. La Superintendencia de Salud, a través de su Intendencia de Prestadores, acredita a los prestadores institucionales y lleva el Registro Nacional de Prestadores Individuales, ambos parte de la garantía de calidad GES. La autorización sanitaria de funcionamiento de un establecimiento la otorga la SEREMI de Salud, por lo que el enunciado mezcla ambos conceptos.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2017 · PREGUNTA 82

¿Cuál de las siguiente actividades o medidas, está relacionado con el principio de ca- lidad de las garantías explícitas de salud (GES)?:

A Autorización sanitaria de prestadores y laboratorios

B Certificación por parte de la superintendencia de los prestadores de salud

C Vigilancia del cumplimiento de plazos

D Convenios entre ISAPRES y prestadores de salud

E Vigilancia epidemiológica

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Certificación por parte de la superintendencia de los prestadores de salud). La certificación asegura que el prestador cumple con los estándares de calidad.

▶ VER CLASE 7.01.3.049 Financiamiento del sector salud

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.1 · Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

QUÉ HAY QUE SABER

- Fuentes: cotización legal de salud de 7% de la remuneración imponible (dependientes, independientes y pensionados) más aporte fiscal general, que financia especialmente a los tramos de menores ingresos y la infraestructura pública.
- FONASA tramos A, B, C y D según ingreso; con Copago Cero (desde 2022) la atención institucional en red pública es gratuita en los cuatro tramos; el tramo A no tiene Libre Elección.
- APS municipal: aporte per cápita por persona inscrita y validada, que financia el Plan de Salud Familiar, con aportes municipales complementarios.
- GES: protección financiera con copago 0% en FONASA y tope 20% en ISAPRE, con deducible anual máximo por problema de salud.
- Ley Ricarte Soto: financiamiento 100% estatal, universal, sin copago ni deducible.

PREGUNTAS · 2

PREGUNTA REAL · EUNACOM AGOSTO 2021 · PREGUNTA 128

La atención primaria municipal entrega a su población inscrita el Plan de Salud Familiar, una canasta de prestaciones para el niño, la mujer, el adulto y el adulto mayor. **¿Cómo se financia el Plan de Salud Familiar, ofrecido por el sistema de atención primaria de salud de Chile?**

A Transferencias por prestaciones otorgadas

B Aportes de fondos municipales

C Transferencias por plan de salud

D Aporte per cápita, en razón del número de inscritos

E Copago de los usuarios

Respuesta D. La atención primaria municipal se financia principalmente con el aporte per cápita, un monto fijo por cada persona inscrita y validada en el establecimiento, que financia el Plan de Salud Familiar. Los aportes municipales son complementarios y no hay copago en la red pública.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2015 · PREGUNTA 94

¿Cómo se financia el seguro público de salud?

A El aporte estatal, desde los impuestos generales

B El aporte tripartito del estado, los empleadores y trabajadores

C El aporte de las mutuales

D El 7% de los trabajadores

E El aporte de los empleadores

Respuesta A. Fonasa se financia por el aporte estatal (el estado se financia por los impuestos). En segundo lugar por el aporte de los trabajadores. Los empleadores no aportan.

▶ VER CLASE 7.01.3.050 Rol del médico en la generación y uso de la información

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.13 · Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

QUÉ HAY QUE SABER

- El médico es generador y usuario de información: ficha clínica, certificado de defunción, notificación de enfermedades, licencias médicas y registros estadísticos (REM) alimentan las estadísticas vitales del DEIS-MINSAL y del INE.
- La calidad del llenado condiciona el diagnóstico de situación: el certificado de defunción es la fuente primaria de las estadísticas de mortalidad.
- Ficha clínica: propiedad del paciente; el establecimiento es custodio y debe conservarla al menos 15 años desde la última atención.
- Notificar enfermedades en Epivigila: inmediata o diaria según el decreto; omitir es infracción sanitaria.
- Usar los datos para decidir: priorizar problemas, evaluar programas y guiar la práctica clínica; respetar siempre la confidencialidad.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Paciente de 74 años con diabetes mellitus tipo 2 de 20 años de evolución, que desarrolló enfermedad renal crónica terminal. Fallece por una hiperkalemia grave que le produjo un paro cardiorrespiratorio. El médico debe llenar el certificado de defunción. **¿Cuál debe registrarse como causa básica de muerte?**

A Diabetes mellitus tipo 2

B Paro cardiorrespiratorio

C Hiperkalemia

D Enfermedad renal crónica

E Vejez

Respuesta A. La causa básica es la enfermedad que inició la cadena de acontecimientos que llevó a la muerte, y es la que se usa en las estadísticas de mortalidad. Se anota en la última línea de la parte I, con las causas intermedias y la inmediata por encima. El paro cardiorrespiratorio es un mecanismo, no una causa, y no debe registrarse.

▶ VER CLASE 7.01.3.051 Certificado de defunción, licencia médica, notificación de enfermedades

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.4 · Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile
Salud Pública 21.13 · Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

QUÉ HAY QUE SABER

- Certificado de defunción: cadena de causas (inmediata, intermedia y básica); la básica se tabula. Nunca anotar paro cardiorrespiratorio ni falla multiorgánica como causa única o básica (mecanismos universales).
- El médico clínico firma solo si la muerte es natural por enfermedad conocida; en muerte violenta (homicidio, suicidio, accidente), intoxicación, bajo custodia, muerte quirúrgica inexplicable o cadáver hallado sin causa clara, no firma: preserva el cuerpo y notifica a Carabineros, PDI o Ministerio Público (SML); si el origen fue violento sigue siendo médico-legal aunque muera semanas después.
- Autopsia clínica: causas naturales, exige consentimiento familiar; médico-legal: la ordena el fiscal, la familia no puede oponerse y firma el médico legista.
- Licencia médica: certifica incapacidad laboral transitoria y la COMPIN autoriza, reduce o rechaza; la licencia falsa o sin evaluación clínica es delito (presidio, multa 50-500 UTM, inhabilitación).
- Notificación obligatoria (DS N°7): inmediata ante sospecha (meningococo, hantavirus, sarampión, cólera, brotes de ETA) y dentro de 24 h para TBC, sífilis, gonorrea, VIH, hepatitis virales y coqueluche; deber de denunciar delitos en 24 h.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 4

Un paciente con antecedente de cáncer de próstata sufre un tromboembolismo pulmonar, luego falla respiratoria, luego un paro cardíaco, y finalmente la muerte. **¿Cuál es la causa inmediata de muerte en el certificado de defunción?**

A Cáncer de próstata
B Tromboembolismo pulmonar
C Paro cardíaco
D Falla respiratoria
E Trombosis venosa profunda

Respuesta D. La cadena completa es: cáncer de próstata como causa básica, tromboembolismo pulmonar como causa intermedia, y falla respiratoria como causa inmediata, la condición final antes de morir. El paro cardíaco es el mecanismo terminal universal y nunca se escribe en el certificado, por más que sea literalmente lo último que ocurrió.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Médico de urgencia rural atiende a un niño de 6 años con fiebre alta, cefalea, vómitos, rigidez de nuca y petequias en extremidades inferiores de 8 horas de evolución. Sospecha una enfermedad meningocócica invasora y solicita punción lumbar. **¿Cuál es la conducta correcta respecto a la notificación epidemiológica?**

A Notificar de inmediato a la SEREMI de Salud, sin esperar el resultado del citoquímico ni el cultivo de LCR
B Esperar el resultado del Gram del líquido cefalorraquídeo antes de notificar
C Notificar dentro de 24 horas, ya que se trata de una enfermedad de notificación diaria
D Notificar solo si el hemocultivo confirma Neisseria meningitidis
E No corresponde notificar hasta que el paciente sea dado de alta

Respuesta A. La enfermedad meningocócica invasora es de notificación inmediata ante la sola sospecha clínica, sin esperar la confirmación de laboratorio, para permitir la quimioprofilaxis oportuna de los contactos estrechos.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un anciano de 82 años, diabético e hipertenso, sufre un asalto en la vía pública y recibe un golpe contuso severo en el cráneo, que le produce un hematoma subdural traumático. Es operado y derivado a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde fallece a los 25 días de ingreso, por una neumonía aspirativa y un shock séptico. El médico residente de turno evalúa si debe firmar el certificado de defunción, por tratarse de una muerte hospitalaria tardía. **¿Cuál es la conducta correcta?**

A Firmar el certificado, con shock séptico como causa básica de defunción
B No firmar el certificado: la muerte es médico-legal, por el origen traumático inicial
C Firmar el certificado, escribiendo paro cardiorrespiratorio como causa básica
D Firmar el certificado solo si la familia lo autoriza por escrito
E Solicitar una autopsia clínica antes de decidir quién firma

Respuesta B. Si el evento causal inicial fue violento o accidental, la muerte se clasifica como médico-legal, sin importar cuánto tiempo pase internado ni que la causa inmediata final sea médica. El residente no debe firmar el certificado: debe preservar el cuerpo y notificar para que el caso se derive al Servicio Médico Legal.

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2024 · PREGUNTA 52

Si detecto una infección que debe tener notificación obligatoria inmediata. Conducta:

A Avisar al delegado de epidemiología
B Notificar inmediatamente a la SEREMI
C Reportar en plataforma digital durante las primeras 24 hrs
D Staphylococcus aureus
E Streptococcus pneumoniae

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Notificar inmediatamente a la SEREMI (opción B).

PREGUNTA REAL · EUNACOM DICIEMBRE 2022 · PREGUNTA 145

Un paciente de 80 años, con antecedente de cáncer de próstata avanzado, en tratamiento con hormonoterapia, presenta deterioro súbito del estado respiratorio, evolucionando con taquicardia y desaturación arterial. Se solicita angioTAC, que demuestra un tromboembolismo pulmonar derecho, por lo que se inicia terapia anticoagulante, sin embargo, evoluciona en malas condiciones generales, cayendo en insuficiencia respiratoria, colapso circulatorio y, finalmente, ausencia de pulso y respiración, por lo que se realiza reanimación avanzada, con múltiples desfibrilaciones y adrenalina, sin respuesta, por lo que se declara la muerte. ¿Cuál de las siguientes debe ser la causa de muerte inmediata en el certificado de defunción?

A Cáncer de próstata
B Insuficiencia respiratoria aguda
C Tromboembolismo pulmonar
D Falla multiorgánica
E Fibrilación ventricular

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Tromboembolismo pulmonar (opción C).

▶ VER CLASE 7.01.3.052

Ejercicio profesional: marcos ético, legal y gremial

DÓNDE SE ENSEÑA

Salud Pública 21.11 · Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento
Salud Pública 21.13 · Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia
Salud Pública 21.14 · Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Marco legal: el Código Sanitario regula el ejercicio de las profesiones de salud (art. 112 exige título de médico cirujano; art. 113 define el acto médico); ejercer sin título es delito (ejercicio ilegal). El Código de Ética del Colegio Médico es gremial y solo obliga a los colegiados.
- Bioética (Beauchamp y Childress): autonomía, no maleficencia (prioridad sobre beneficencia), beneficencia y justicia. Consentimiento informado: información, comprensión, voluntariedad y capacidad; excepciones: urgencia vital y riesgo para la salud pública.
- Adulto competente que rechaza transfusión: se respeta con constancia escrita y se ofrecen alternativas; menor con riesgo vital: se transfunde igual y se recurre al tribunal de familia después; doble efecto en paliativos justificado por la intención de aliviar, no de matar.
- Comité de Ética Asistencial: consultivo y no vinculante; una urgencia vital nunca se demora esperándolo.
- Deber de denuncia en 24 h (Fiscalía, PDI o Carabineros) de lesiones por delito, agresión sexual, maltrato infantil y VIF grave; omitirla es delito. Interrupción del embarazo (Ley 21.030): tres causales; objeción de conciencia se suspende en riesgo vital sin otro médico disponible.

PREGUNTAS · 5

PREGUNTA REAL · PREGUNTA DEL BANCO EUNACOM

Médico paliativista atiende a una paciente de 78 años con cáncer de páncreas metastásico en fase de agonía, con dolor irruptivo refractario de intensidad máxima y agitación terminal severa. Decide titular una infusión continua de morfina y midazolam a dosis analgésicas plenas para controlar el sufrimiento, sabiendo que la medicación podría secundariamente acelerar una depresión respiratoria. **¿Bajo qué principio bioético se justifica esta conducta médica?**

A Principio del doble efecto
B Principio de autonomía paternalista
C Principio de eutanasia pasiva voluntaria
D Principio de justicia conmutativa
E Principio de no maleficencia inversa

Respuesta A. El principio del doble efecto justifica una acción con un efecto bueno buscado, aliviar el dolor refractario en agonía, y un efecto malo no buscado, el riesgo de depresión respiratoria, siempre que el acto sea bueno en sí mismo, la intención exclusiva sea el alivio, y el efecto positivo no se consiga a través del negativo. No es eutanasia, porque la intención del médico nunca es provocar la muerte.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 167

Un médico recién titulado quiere conocer qué norma regula en Chile el ejercicio de las profesiones de la salud, incluida la medicina. **¿Cuál es el cuerpo normativo que regula el ejercicio de la profesión médica en Chile?**

A Constitución Política de la República
B Código del Colegio Médico de Chile
C Ley que crea el Ministerio de Salud
D Ley de Derechos y Deberes del Paciente
E Código Sanitario

Respuesta E. El Código Sanitario regula el ejercicio de las profesiones de la salud, además del control de enfermedades transmisibles, medicamentos y establecimientos, con fiscalización de la SEREMI de Salud. El Código de Ética del Colegio Médico es gremial y solo obliga a sus colegiados; la Ley 20.584 regula los derechos del paciente.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Niño de 7 años politraumatizado ingresa con shock hipovolémico grado IV por rotura esplénica y hemoperitoneo crítico, hemoglobina de 4,2. El cirujano indica laparotomía urgente y transfusión inmediata. Ambos padres, testigos de Jehová, prohíben la transfusión de sangre a su hijo por motivos religiosos. **¿Cuál es la conducta médica y médico-legal correcta?**

A Respetar la decisión de los padres y no transfundir
B Transfundir y operar de inmediato, e interponer una medida de protección
C Esperar la autorización de un juez antes de intervenir
D Solicitar una segunda opinión de otro cirujano antes de decidir
E Convocar al Comité de Ética Asistencial antes de intervenir

Respuesta B. Ante un menor con riesgo vital inminente, la autonomía de los padres se subordina al derecho a la vida y al interés superior del niño. El médico debe transfundir y operar de inmediato, y recién después interponer una medida de protección ante el tribunal de familia para respaldar jurídicamente el procedimiento; ni esperar a un juez ni convocar al comité de ética son opciones válidas cuando la vida corre riesgo inmediato.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

En un hospital provincial de baja complejidad, una gestante de 16 semanas ingresa a la urgencia obstétrica con un shock hipovolémico severo por rotura uterina espontánea y hemoperitoneo masivo, con riesgo de muerte inminente. Es Causal 1 de la Ley IVE. El único gineco-obstetra de turno está inscrito como objetor de conciencia, manifiesta que por sus convicciones no realizará la intervención, y solicita trasladar a la paciente a un hospital regional ubicado a 3 horas de distancia. **¿Cuál es la conducta correcta?**

A Trasladar a la paciente al hospital regional, respetando la objeción del médico

B El médico debe intervenir de inmediato: la objeción se suspende ante el riesgo vital sin otro médico disponible

C Esperar la autorización de la dirección del hospital antes de decidir

D Convocar al Comité de Ética Asistencial antes de intervenir

E Sedar a la paciente y esperar a que llegue otro especialista

Respuesta B. La objeción de conciencia no es absoluta: cesa por ley cuando hay riesgo vital inminente bajo la Causal 1 y no existe otro médico disponible. Trasladarla a tres horas de distancia, esperar una autorización o convocar a un comité expone a la paciente a morir mientras se completa un trámite; el deber de preservar la vida prima sobre la objeción personal en ese escenario extremo.

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 64

Durante una evaluación de calidad en un hospital se constata que un anestesista, en conjunto con un técnico en anestesia, utilizan tres pabellones de manera simultánea. El informe del hospital comunica que aquella es la práctica habitual. ¿A qué tipo de práctica corresponde este caso?

A Error médico

B Impericia

C Negligencia médica

D Eficiencia

E Imprudencia

Respuesta E. Imprudencia médica: En el contexto médico, la imprudencia se define como la realización de acciones temerarias que aumentan innecesariamente el riesgo de complicaciones y problemas para los pacientes. La impericia se refiere a la falta de conocimientos o habilidades necesarios para realizar una actividad o procedimiento médico. La negligencia es la falta del debido cuidado, generalmente por omisión. La eficiencia, por otro lado, busca optimizar el uso de los recursos, pero siempre debe hacerse...

▶ VER CLASE 7.01.3.053 Derecho GES a atención integral de salud en agresión sexual aguda

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.2 · Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos

QUÉ HAY QUE SABER

- La garantía GES de atención integral de la agresión sexual aguda asegura atención oportuna a la víctima, sin depender de la denuncia ni del peritaje.
- Incluye manejo de lesiones, anticoncepción de emergencia, profilaxis de ITS, VIH (idealmente antes de 72 horas) y hepatitis B, toma y custodia de muestras, apoyo psicosocial y seguimiento.
- La atención de salud no se posterga por el peritaje; el establecimiento debe resguardar la cadena de custodia.
- Deber legal del médico de denunciar (24 h) la sospecha de agresión sexual ante Fiscalía, PDI o Carabineros; en menores se protege y se registra textualmente el relato sin interrogatorios repetidos para evitar revictimización.
- La ausencia de lesiones no descarta abuso. Si corresponde (causal 3, Ley 21.030): interrupción hasta 12 semanas, o 14 si es menor de 14 años.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Mujer de 22 años consulta en un servicio de urgencia 12 horas después de haber sido víctima de una violación con penetración vaginal sin preservativo, por un desconocido. Está hemodinámicamente estable, con lesiones leves. **Según la garantía GES de atención integral en agresión sexual aguda, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A Derivarla al Servicio Médico Legal sin atenderla

B Atención integral: anticoncepción de emergencia, profilaxis de ITS y VIH, vacuna de hepatitis B, toma de muestras forenses, apoyo psicológico y denuncia

C Esperar un test de embarazo en 2 semanas antes de indicar anticoncepción

D Indicar profilaxis de VIH solo si se confirma que el agresor es VIH positivo

E Indicar solo analgesia y control en atención primaria

Respuesta B. La garantía GES asegura atención integral oportuna a víctimas de agresión sexual aguda: manejo de lesiones, anticoncepción de emergencia, profilaxis de ITS, VIH (idealmente antes de 72 horas) y hepatitis B, toma y custodia de muestras, apoyo psicosocial y seguimiento. La atención de salud no se posterga por el peritaje, y el establecimiento debe hacer la denuncia.

▶ VER CLASE 7.01.3.054 Otorgamiento, uso y sanciones por mal uso de licencias médicas

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.14 · Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Licencia médica: acto médico y documento legal oficial que certifica incapacidad laboral transitoria y justifica la ausencia; origina subsidio. La COMPIN autoriza, reduce o rechaza; la emisión exige evaluación clínica real.

- Tipo 1: enfermedad o accidente común (ej. amigdalitis aguda); tipos 5-6: accidente del trabajo y enfermedad profesional (Ley 16.744), a cargo del organismo administrador (mutualidad o ISL), con notificación DIAT; accidente de trayecto directo es accidente del trabajo.
- Emitir licencia falsa o sin evaluación ni patología que la justifique es delito: presidio, multas de 50 a 500 UTM a beneficio fiscal e inhabilitación temporal o perpetua para emitir licencias y ejercer cargos públicos de salud.
- No se otorga a solicitud del paciente sin justificación clínica; debe constar diagnóstico, reposo y duración.
- Responsabilidad compartida: sanciones también al trabajador que la utilice fraudulentamente.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA REAL · EUNACOM ENERO 2023 · PREGUNTA 5

Se evalúa cuál de las siguientes situaciones corresponde a una licencia médica tipo I, es decir, por enfermedad o accidente común. **¿Cuál de las siguientes corresponde a una licencia médica tipo I?**

A Amigdalitis aguda

B Accidente laboral con fractura

C Enfermedad profesional por ruido

D Reposo por embarazo de alto riesgo

E Licencia por maternidad

Respuesta A. La licencia tipo I es por enfermedad o accidente común, es decir, sin relación con el trabajo ni con el embarazo. Una amigdalitis aguda es una enfermedad común corriente. El accidente laboral y la enfermedad profesional se cubren por la ley de accidentes del trabajo, no como tipo I; el embarazo de alto riesgo y la maternidad tienen sus propios regímenes de licencia, distintos del tipo I.

▶ VER CLASE 7.01.3.055 Conceptos básicos de administración de establecimientos de salud

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.15 · Gestión y Administración en Salud: Demografía, Planificación, Programación, Organización y Dirección

QUÉ HAY QUE SABER

- Establecimientos de salud: cumplen funciones asistenciales con apoyo administrativo, logístico y técnico; la gestión se organiza por centros de responsabilidad y unidades de apoyo.
- Elementos básicos: planificación anual (programación de actividades y metas), organización por niveles, dirección clínica y administrativa, control y evaluación con indicadores (cobertura, rendimiento, ocupación de camas, promedio de días de estada, giro de camas).
- Calidad y seguridad: acreditación de prestadores institucionales (Superintendencia), autorización sanitaria (SEREMI) y registro de prestadores individuales.
- Gestión de recursos: personal, insumos, infraestructura y financiamiento (per cápita en APS; pago por prestación y por GRD en hospitales).
- Hospitales autogestionados en red con autonomía de gestión; el director es responsable de resultados y cumplimiento de normas.

PREGUNTAS · 1

PREGUNTA DE PRÁCTICA

El director de un hospital revisa los indicadores de gestión de camas del último trimestre. Quiere conocer qué porcentaje de las camas disponibles estuvo efectivamente ocupado durante el período. **¿Qué indicador debe revisar?**

A Índice de rotación

B Promedio de días de estada

C Índice ocupacional

D Letalidad hospitalaria

E Intervalo de sustitución

Respuesta C. El índice ocupacional es días-cama ocupados dividido por días-cama disponibles, por 100. El promedio de días de estada mide cuántos días permanece cada paciente; el índice de rotación, cuántos egresos genera cada cama en el período; y el intervalo de sustitución, el tiempo que una cama queda desocupada entre un egreso y el siguiente ingreso.

▶ VER CLASE 7.01.3.056 Conocimiento de los derechos y deberes del paciente

DÓNDE SE ENSEÑA **Salud Pública** 21.11 · Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento
Salud Pública 21.12 · Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad

QUÉ HAY QUE SABER

- Ley 20.584: el paciente tiene derecho a trato digno, intimidad y pudor, información clara, consentimiento informado, rechazo de tratamiento, confidencialidad, compañía y facilitador intercultural o lingüístico; también a recibir epicrisis al alta y cuenta financiera clara.
- Ficha clínica: propiedad del paciente; el prestador es custodio y debe conservarla al menos 15 años desde la última atención. Acceso legítimo solo para el paciente, su representante legal, herederos, tribunales y Fiscalía, y Superintendencia; el empleador nunca y la aseguradora solo con poder notarial expreso.
- Prohibido fotografiar o grabar al paciente sin consentimiento informado por escrito, incluso con fines docentes; entregar la ficha a quien no corresponde vulnera el secreto médico (sanción administrativa, civil y penal).
- Menores: consentimiento firmado por representante legal, escuchando al adolescente; en el control del adolescente se entrevista solo con la regla de confidencialidad, salvo riesgo vital propio o ajeno o abuso. Urgencia vital: se actúa sin consentimiento.
- Deberes del paciente: entregar información veraz sobre su salud e identidad, respetar al personal y cumplir las normas del establecimiento.

PREGUNTAS · 3

PREGUNTA REAL · EUNACOM JULIO 2024 · PREGUNTA 46

Se pretende realizar un estudio en adolescentes de dieciséis años, que estudian en colegios del sector público. **¿Quién debe firmar el documento de consentimiento informado para autorizar la participación de estos pacientes?**

A El alumno

B El director del establecimiento

C Cualquier pariente mayor de edad

D El apoderado

E El encargado de salud y bienestar estudiantil del establecimiento

Respuesta D. La Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes exige que el consentimiento sea informado y voluntario. En menores de edad, es el representante legal, el apoderado o los padres, quien debe firmarlo, aunque el adolescente tenga derecho a ser escuchado según su edad y madurez. Ni el propio alumno, ni el director, ni un pariente cualquiera sin ese vínculo, ni un funcionario del colegio reemplazan esa representación legal.

PREGUNTA REAL · PREGUNTA DEL BANCO EUNACOM

Paciente de 45 años, lúcido y orientado, ingresa a urgencias con hemorragia digestiva alta grave por úlcera péptica sangrante, con presión de 85 sobre 50 y hemoglobina de 5,8. El paciente manifiesta de forma clara y reiterada que es testigo de Jehová y rechaza categóricamente cualquier transfusión de sangre, aceptando el riesgo vital de su decisión. **¿Cuál es la conducta correcta del médico tratante?**

A Respetar la voluntad del paciente, dejar constancia escrita y firmada, e iniciar alternativas como cristaloides y expansores

B Sedarlo para transfundirlo de emergencia bajo el principio de beneficencia

C Solicitar la intervención de la fuerza pública para obligarlo a aceptar la transfusión

D Declararlo en incompetencia mental transitoria por la hipotensión, para transfundirlo

E Rechazar la atención médica y darle el alta disciplinaria

Respuesta A. Un adulto lúcido, informado y capaz tiene el derecho legal y ético a rechazar cualquier tratamiento, incluso con riesgo de muerte. El médico respeta la decisión, deja constancia firmada en la ficha con testigos, y ofrece el máximo esfuerzo con alternativas no objetadas; sedar al paciente para forzar la transfusión, o declararlo incompetente sin fundamento clínico, vulneran gravemente su autonomía.

PREGUNTA DE PRÁCTICA

Un trabajador de 35 años sufre una crisis de pánico en su horario laboral y acude al servicio de urgencias de una clínica privada. Al día siguiente, el jefe de recursos humanos de la empresa se presenta en la dirección médica con una carta formal timbrada, solicitando una copia íntegra de la ficha clínica de urgencia del trabajador para verificar si su cuadro ameritaba reposo o si existía consumo de sustancias. **¿Cuál es la conducta que debe asumir la dirección del establecimiento de salud?**

A Entregar la ficha completa, porque la carta timbrada de la empresa la respalda formalmente

B Rechazar la solicitud: el empleador no tiene acceso legal a la ficha clínica de su trabajador

C Entregar solo el diagnóstico de ingreso, omitiendo el resto de la ficha

D Pedir la autorización verbal del jefe de servicio para entregar los antecedentes

E Entregar la ficha si el trabajador no reclama en un plazo de cinco días

Respuesta B. Los datos de salud son datos sensibles bajo la Ley 20.584 y la Ley 19.628. El empleador carece de todo derecho legal para acceder a la ficha médica de sus trabajadores, sin importar el motivo laboral invocado ni el formalismo de la carta. Entregarla, completa o parcial, constituye una vulneración del secreto profesional, sancionable por la Superintendencia de Salud e indemnizable en sede civil.